VOLUME COMPLET · VERSION NORMALE

VOLUME 1

Santé publique et démarche de projet

DANS CE VOLUME

01 La santé publique et la promotion de la santé en nutrition

02 Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé

03 Éléments de psychologie sociale

04 Pratiques et comportements alimentaires

05 Littératie en santé

06 Éthique et déontologie en santé publique

07 Démarche de projet (1) : diagnostic, priorités et objectifs

08 Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage

09 Démarche de projet (3) : évaluation et valorisation

Chaque chapitre contient son cours, sa fiche de révision, son cahier d'exercices et ses annales E5.

SOMMAIRE DU VOLUME 1

Santé publique et démarche de projet · version normale

01 **La santé publique et la promotion de la santé en nutrition** — p. 15
Chapitre 1 · cours, fiche, cahier d'exercices, annales · 230 pages

02 **Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé** — p. 245
Chapitre 2 · cours, fiche, cahier d'exercices, annales · 235 pages

03 **Éléments de psychologie sociale** — p. 480
Chapitre 3 · cours, fiche, cahier d'exercices, annales · 252 pages

04 **Pratiques et comportements alimentaires** — p. 732
Chapitre 4 · cours, fiche, cahier d'exercices, annales · 258 pages

05 **Littératie en santé** — p. 990
Chapitre 5 · cours, fiche, cahier d'exercices, annales · 260 pages

06 **Éthique et déontologie en santé publique** — p. 1250
Chapitre 6 · cours, fiche, cahier d'exercices, annales · 264 pages

07 **Démarche de projet (1) : diagnostic, priorités et objectifs** — p. 1514
Chapitre 7 · cours, fiche, cahier d'exercices, annales · 263 pages

08 **Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage** — p. 1777
Chapitre 8 · cours, fiche, cahier d'exercices, annales · 259 pages

09 **Démarche de projet (3) : évaluation et valorisation** — p. 2036
Chapitre 9 · cours, fiche, cahier d'exercices, annales · 269 pages

Les numéros « p. » sont ceux du fichier du volume. À l'intérieur d'un chapitre, le pied de page et le sommaire du chapitre gardent la numérotation du chapitre (Page 1 à N).

Cliquer sur un chapitre pour y aller. Le sommaire détaillé de chaque chapitre, cliquable, suit cette page.

SOMMAIRE DÉTAILLÉ DU VOLUME 1

Santé publique et démarche de projet · version normale · cliquer sur une ligne pour y aller

Chapitre 1 · La santé publique et la promotion de la santé en nutrition 15

Cours 20

1.1 Compétences mobilisées 21

1.2 Croisement référentiel × précisions × indications 22

1.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 22

1.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 23

1.3 Cours 24

1.3.1 Les concepts de santé : du modèle biomédical à « Une seule santé » 24

1.3.2 La santé publique : définitions, missions et approche populationnelle 30

1.3.3 Problème de santé, danger, risque, facteur de risque et facteur de protection 36

1.3.4 Les modes d'intervention en santé publique 38

1.3.5 Les acteurs et les organismes de la santé publique en nutrition 49

1.3.6 Les politiques publiques de santé : élaboration, pilotage, mise en œuvre et déclinaison territoriale 57

1.3.7 Les politiques nutritionnelles de santé publique 63

1.3.8 Le diététicien-nutritionniste en santé publique 70

1.3.9 Fil rouge : le projet « Bien manger, petit budget, grand plaisir » du centre social des Tilleuls 72

1.4 Approfondissements 88

1.4.1 Les données probantes en promotion de la santé 88

1.4.2 Les théories du changement de comportement : premier aperçu 89

1.4.3 Le débat sur les aliments ultra-transformés 89

1.4.4 Promotion de la santé et non-stigmatisation du poids 90

1.4.5 Santé publique, alimentation et climat 91

1.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 92

1.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 93

Méthode 1 – Présenter le cadre de son action en deux minutes (oral E5) 94

Méthode 2 – Lire de façon critique un document de santé publique 95

1.7 L'essentiel à retenir 95

1.8 Entraînement 97

1.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 97

1.8.2 Exercices 99

1.8.3 Questions de réflexion 104

1.8.4 Étude de cas 106

1.8.5 Mises en situation express 106

1.9 Glossaire 110

1.10 Renvois bibliographiques par notion 112

1.12 Bibliographie numérotée 112

Textes fondateurs et définitions 112

Données et surveillance 113

Référentiel, guide et profession 113

Politiques nutritionnelles 113

Profession, organisation, approfondissements 114

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 1.2.2) 114

Fiche de révision et fiches-outils 116

Fiche de révision du chapitre 1 117

Fiches-outils du chapitre 1 120

Cahier d'exercices 126

Partie 1 – Les concepts de santé 129

Partie 2 – La santé publique : définitions, missions et approche populationnelle 140

Partie 3 – Problème de santé, danger, risque, facteurs de risque et de protection 152

Partie 4 – Les modes d'intervention en santé publique 162

Partie 5 – Les acteurs et les organismes de la santé publique en nutrition 173

Partie 6 – Les politiques publiques de santé et leur déclinaison territoriale 184
Partie 7 – Les politiques nutritionnelles de santé publique 195
Partie 8 – Le diététicien-nutritionniste en santé publique et la démarche de projet 205
Bilan : grille d'auto-évaluation 217

Annales E5 219
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 221
S1 – « Manger, c'est aussi s'insérer » : les jeunes d'une mission locale 221
S2 – « Prendre soin de soi quand on prend soin d'un proche » : un atelier pour les aidants 224
S3 – Soignants de nuit d'un centre hospitalier : du projet à l'atelier 227
Partie II – Les corrigés détaillés 229
Corrigé S1 – « Manger, c'est aussi s'insérer » : les jeunes d'une mission locale 229
Corrigé S2 – « Prendre soin de soi quand on prend soin d'un proche » : un atelier pour les aidants 235
Corrigé S3 – Soignants de nuit d'un centre hospitalier : du projet à l'atelier 240
Grille d'auto-évaluation 244

Chapitre 2 · Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé 245

Cours 249
2.1 Compétences mobilisées 251
2.2 Croisement référentiel × précisions × indications 251
2.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 252
2.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 252
2.3 Cours 253
2.3.1 Les déterminants de santé 254
2.3.2 Inégalités sociales et territoriales de santé 262
2.3.3 Mesurer l'état de santé : les indicateurs démographiques 270
2.3.4 Les indicateurs de mortalité et de morbidité 274
2.3.5 Les sources de données et le portrait de santé d'un territoire 281
2.3.6 Les indicateurs de l'état nutritionnel d'une population 284
2.3.7 Les transitions démographique, épidémiologique et nutritionnelle 287
2.3.8 Le fardeau des maladies chroniques liées à la nutrition en France 290
2.3.9 Mesurer l'association entre un facteur et un problème de santé 294
2.3.10 Les inégalités sociales de santé dans le champ de l'alimentation 298
2.3.11 Représenter et commenter des données épidémiologiques 300
2.3.12 Les grandes enquêtes et cohortes en nutrition 302
2.3.13 Agir sur les déterminants : leviers d'action et évaluation d'impact sur la santé 304
2.3.14 Les indicateurs de santé de la périnatalité et de l'enfance 306
2.3.15 Le coût d'une alimentation favorable à la santé 308
2.3.16 Fil rouge : le portrait de santé du quartier des Tilleuls 310
Cas guidés : du constat à la décision 311
Cas guidé 1 – Une surmortalité cardio-vasculaire 311
Cas guidé 2 – Une action a-t-elle réduit les inégalités ? 312
2.4 Approfondissements 313
2.4.1 Les déterminants commerciaux de la santé 313
2.4.2 Mesurer la défavorisation d'un territoire 314
2.4.3 Les « 1000 premiers jours » et le parcours de vie 315
2.4.4 Lire un indicateur avec un esprit critique 315
2.4.5 L'exposome et les déterminants environnementaux 316
2.4.6 Mesurer l'insécurité alimentaire 317
2.4.7 Le piège du raisonnement écologique 318
2.4.8 Santé mentale et alimentation : une relation dans les deux sens 318
2.4.9 Femmes et hommes : des écarts de santé à interpréter 319
2.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 319
2.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 320
Méthode 1 – Présenter un diagnostic de territoire à l'oral en 3 minutes 321
Méthode 2 – Répondre à une question « Calculez et interprétez » 322
Méthode 3 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve 322
2.7 L'essentiel à retenir 323

2.8 Entraînement 325
2.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 325
2.8.2 Exercices 327
2.8.3 Questions de réflexion 330
2.8.4 Étude de cas 331
2.8.5 Mises en situation express 332
2.8.6 Exercices complémentaires 334
2.8.7 Exercices de synthèse 335
2.8.8 Deuxième étude de cas 338
2.8.9 Mises en situation express complémentaires 339
2.9 Glossaire 340
2.10 Renvois bibliographiques par notion 341
2.12 Bibliographie numérotée 341
Cours du CNED (contrôle de conformité, section 2.2.2) 343

Fiche de révision et fiches-outils 345
Fiche de révision du chapitre 2 346
Fiches-outils du chapitre 2 349

Cahier d'exercices 352
Partie 1 – Les déterminants de santé 355
Partie 2 – Les inégalités sociales et territoriales de santé 371
Partie 3 – Les indicateurs démographiques 382
Partie 4 – Mortalité, morbidité et standardisation 393
Partie 5 – Sources de données, portrait de territoire et état nutritionnel 404
Partie 6 – Transitions et fardeau des maladies chroniques 416
Partie 7 – Mesurer une association, raisonner sur la causalité 427
Partie 8 – Représenter des données, coût de l'alimentation, agir sur les déterminants 437
Bilan : grille d'auto-évaluation 450

Annales E5 452
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 454
S1 – « Récolter sans s'oublier » : la santé des saisonniers agricoles d'une vallée arboricole 454
S2 – « Cuisiner sans cuisine » : un atelier pour des familles hébergées à l'hôtel 457
S3 – Vivre avec un trouble psychique et bien manger : un groupe d'entraide mutuelle 460
Partie II – Les corrigés détaillés 463
Corrigé S1 – « Récolter sans s'oublier » : la santé des saisonniers agricoles 463
Corrigé S2 – « Cuisiner sans cuisine » : un atelier pour des familles hébergées à l'hôtel 469
Corrigé S3 – Vivre avec un trouble psychique et bien manger : un groupe d'entraide mutuelle 474
Grille d'auto-évaluation 479

Chapitre 3 · Éléments de psychologie sociale 480

Cours 484
3.1 Compétences mobilisées 486
3.2 Croisement référentiel × précisions × indications 486
3.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 487
3.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 487
3.3 Cours 488
3.3.1 Psychologie, sociologie, anthropologie : trois regards sur le mangeur 489
3.3.2 Identité individuelle et sociale ; socialisation 492
3.3.3 Représentations, normes, valeurs ; culture et interculturalité 496
3.3.4 La relation sociale et ses dynamiques 502
3.3.5 Les compétences psychosociales 510
3.3.6 Image corporelle, émotions, estime de soi 513
3.3.7 Connaître les publics et comprendre le changement de comportement 516
3.3.8 Communiquer et écouter : les bases de la relation éducative 524
3.3.9 L'esprit de l'entretien motivationnel appliqué au collectif 527
3.3.10 Animer un groupe : étapes, rôles et styles d'animation 531
3.3.11 La motivation et les biais de décision 536

3.3.12 Mesurer attitudes et représentations 539
3.3.13 Un modèle intégrateur : COM-B et la roue du changement de comportement 543
3.3.14 Adapter l'approche psychosociale aux publics 547
3.3.15 Concevoir une séance qui développe les compétences psychosociales en nutrition 549
3.3.16 Fil rouge : les représentations et les dynamiques du groupe des Tilleuls 550
3.3.17 Trois cas guidés pour s'entraîner à l'analyse psychosociale 550
3.4 Approfondissements 553
3.4.1 Néophobie alimentaire et exposition répétée 553
3.4.2 Les normes sociales comme levier 554
3.4.3 L'influence des réseaux sociaux 555
3.4.4 La pair-éducation et les personnes relais 556
3.4.5 La motivation des enfants et des adolescents 557
3.4.6 Les émotions dans l'apprentissage 558
3.4.7 Précarité alimentaire : honte, dignité et pouvoir d'agir 559
3.4.8 Le numérique dans l'accompagnement du changement 559
3.4.9 Les personnes âgées : vieillissement, isolement et plaisir de manger 560
3.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 561
3.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 562
Méthode 1 – Justifier un choix d'animation par un modèle, à l'oral 563
Méthode 2 – Analyser une situation de groupe en quatre questions 563
Méthode 3 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve 563
3.7 L'essentiel à retenir 565
3.8 Entraînement 566
3.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 566
3.8.2 Exercices 567
3.8.3 Questions de réflexion 571
3.8.4 Étude de cas 571
3.8.5 Mises en situation express 572
3.8.6 Exercices complémentaires 574
3.9 Glossaire 576
3.10 Renvois bibliographiques par notion 577
3.12 Bibliographie numérotée 577
Cours du CNED (contrôle de conformité, section 3.2.2) 578

Fiche de révision et fiches-outils 580
Fiche de révision du chapitre 3 581
Fiches-outils du chapitre 3 583

Cahier d'exercices 587
Partie 1 – Regards sur le mangeur, socialisation et identité 590
Partie 2 – Représentations, normes, valeurs et culture 604
Partie 3 – Influence sociale, attitudes et stigmatisation 617
Partie 4 – Compétences psychosociales, émotions, image du corps et estime de soi 632
Partie 5 – Les modèles du changement de comportement 645
Partie 6 – Communiquer, écouter, accompagner la motivation 659
Partie 7 – Animer un groupe, motiver, tenir compte des biais de décision 673
Partie 8 – Mesurer les attitudes et les représentations ; cas complet 685
Bilan : grille d'auto-évaluation 699

Annales E5 701
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 703
S1 – « Un vrai casse-croûte de chantier » : représentations et habitudes alimentaires des apprentis d'un CFA du bâtiment 703
S2 – « Les hommes aux fourneaux » : un atelier pour des hommes âgés qui vivent seuls 707
S3 – Vers l'autonomie : des jeunes de la protection de l'enfance qui apprennent à se nourrir seuls 710
Partie II – Les corrigés détaillés 713
Corrigé S1 – « Un vrai casse-croûte de chantier » : les apprentis d'un CFA du bâtiment 713
Corrigé S2 – « Les hommes aux fourneaux » : un atelier pour des hommes âgés qui vivent seuls 720
Corrigé S3 – Vers l'autonomie : des jeunes de la protection de l'enfance 725
Grille d'auto-évaluation 731

Chapitre 4 · Pratiques et comportements alimentaires 732

Cours 736
- 4.1 Compétences mobilisées 738
- 4.2 Croisement référentiel × précisions × indications 738
  - 4.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 739
  - 4.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 739
- 4.3 Cours 740
  - 4.3.1 Les rôles de l'acte alimentaire 741
  - 4.3.2 Le comportement alimentaire : besoin, oralité, pulsion 743
  - 4.3.3 La régulation et la dérégulation du comportement alimentaire 744
  - 4.3.4 Les déterminants du comportement alimentaire 752
  - 4.3.5 L'évolution des pratiques alimentaires et le syncrétisme culinaire 756
  - 4.3.6 Les principales pratiques alimentaires actuelles 759
  - 4.3.7 Accompagner l'évolution des pratiques alimentaires 765
  - 4.3.8 Les rythmes et la structure des prises alimentaires 767
  - 4.3.9 Le développement du comportement alimentaire de l'enfant 771
  - 4.3.10 Les comportements alimentaires selon les âges de la vie 775
  - 4.3.11 Observer et mesurer les comportements alimentaires 780
  - 4.3.12 Vers une alimentation durable : santé et environnement 784
  - 4.3.13 Les troubles du comportement alimentaire : comprendre pour prévenir et orienter 788
  - 4.3.14 Les stratégies alimentaires des ménages en situation de précarité 791
  - 4.3.15 Les pratiques alimentaires religieuses en détail 794
  - 4.3.16 La dégustation et l'analyse sensorielle au service de l'éducation 797
  - 4.3.17 Repères sur quelques cultures culinaires 797
  - 4.3.18 Fil rouge : les pratiques alimentaires des familles des Tilleuls 799
  - 4.3.19 Six cas guidés pour s'entraîner à l'analyse d'un comportement alimentaire 800
- 4.4 Approfondissements 804
  - 4.4.1 Le goût : un apprentissage 804
  - 4.4.2 Manger en pleine conscience et approches non restrictives 806
  - 4.4.3 La dimension sociale du repas et la santé 806
  - 4.4.4 Le gaspillage alimentaire 806
  - 4.4.5 Alimentation et ultra-transformation : comprendre le débat 806
  - 4.4.6 Nouveaux aliments et acceptabilité : insectes et substituts végétaux 808
- 4.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 810
- 4.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 812
  - 4.6.1 Préparer l'oral : défendre une analyse de comportement alimentaire 813
  - 4.6.2 Préparer l'atelier culinaire : lire le contexte imposé avec les notions du chapitre 814
  - 4.6.3 Dix questions d'entretien pour s'entraîner 815
- 4.7 L'essentiel à retenir 817
- 4.8 Entraînement 817
  - 4.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 817
  - 4.8.2 Exercices 819
  - 4.8.3 Questions de réflexion 822
  - 4.8.4 Étude de cas 823
  - 4.8.5 Mises en situation express 823
  - 4.8.6 Exercices complémentaires 826
  - 4.8.7 Exercices d'approfondissement 827
- 4.9 Glossaire 828
- 4.10 Renvois bibliographiques par notion 829
- 4.12 Bibliographie numérotée 829
  - Cours du CNED (contrôle de conformité, section 4.2.2) 830

Fiche de révision et fiches-outils 832
- Fiche de révision du chapitre 4 833
- Fiches-outils du chapitre 4 835

Cahier d'exercices 839
Partie 1 – Les rôles de l'acte alimentaire et le comportement alimentaire 842
Partie 2 – La régulation du comportement alimentaire 857
Partie 3 – Les dérégulations : restriction, émotions, troubles du comportement alimentaire 871
Partie 4 – Les déterminants du comportement alimentaire 887
Partie 5 – Évolution des pratiques et pratiques alimentaires actuelles 901
Partie 6 – Les rythmes alimentaires et les âges de la vie 914
Partie 7 – Le comportement alimentaire de l'enfant 927
Partie 8 – Observer, mesurer et agir pour une alimentation durable 939
Bilan : grille d'auto-évaluation 957

Annales E5 959
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 961
S1 – « Ici, on mange quand on peut » : rythmes, grignotage et prise de poids en maison d'arrêt 961
S2 – « Fait maison en 30 minutes » : un atelier pour des parents qui élèvent seuls leurs enfants 964
S3 – « Loin de tout, mais pas sans ressources » : pratiques alimentaires dans une communauté de communes rurale 968
Partie II – Les corrigés détaillés 971
Corrigé S1 – « Ici, on mange quand on peut » : rythmes, grignotage et prise de poids en maison d'arrêt 971
Corrigé S2 – « Fait maison en 30 minutes » : un atelier pour des parents qui élèvent seuls leurs enfants 978
Corrigé S3 – « Loin de tout, mais pas sans ressources » : pratiques alimentaires dans une communauté de communes rurale 983
Grille d'auto-évaluation 989

Chapitre 5 · Littératie en santé 990

Cours 994
5.1 Compétences mobilisées 995
5.2 Croisement référentiel × précisions × indications 995
5.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 996
5.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 996
5.3 Cours 997
5.3.1 Définir la littératie en santé 997
5.3.2 Les données en France 1004
5.3.3 Pourquoi la littératie compte en santé publique 1008
5.3.4 Repérer sans stigmatiser 1011
5.3.5 Adapter les messages et les supports 1015
5.3.6 Vérifier la compréhension : le « faire dire » 1024
5.3.7 Intégrer la littératie à chaque étape du projet 1027
5.3.8 Lire une étiquette : un savoir-faire de littératie alimentaire 1029
5.3.9 Comprendre et présenter des chiffres : la numératie en santé 1034
5.3.10 La littératie numérique et l'inclusion numérique en pratique 1039
5.3.11 Communiquer avec des personnes allophones 1043
5.3.12 Concevoir et tester un support accessible : un exemple complet 1047
5.3.13 Choisir et concevoir des outils pédagogiques accessibles 1049
5.3.14 Animer un atelier accessible : une séquence type 1051
5.3.15 Fil rouge : la littératie au centre social des Tilleuls 1053
5.3.16 Six cas guidés pour s'entraîner à intégrer la littératie 1054
5.4 Approfondissements 1058
5.4.1 La littératie numérique en santé (e-santé) 1058
5.4.2 La médiation en santé et l'interprétariat 1059
5.4.3 Les organisations « amies de la littératie » 1061
5.4.4 La littératie en santé des professionnels et des organisations 1062
5.4.5 L'intelligence artificielle et la simplification des textes 1064
5.4.6 Développer la littératie alimentaire des enfants à l'école 1065
5.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 1067
5.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 1068
Méthode 1 – Justifier à l'oral E5 la prise en compte de la littératie dans un projet 1069
Méthode 2 – Analyser un support dans une question écrite de l'épreuve 1070
Méthode 3 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve 1071
Méthode 4 – Relier la littératie aux autres chapitres du cours 1072

5.7 L'essentiel à retenir 1073
5.8 Entraînement 1074
5.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 1074
5.8.2 Exercices 1075
5.8.3 Questions de réflexion 1079
5.8.4 Étude de cas 1080
5.8.5 Mises en situation express 1080
5.8.6 Exercices complémentaires 1083
5.9 Glossaire 1084
5.10 Renvois bibliographiques par notion 1085
5.12 Bibliographie numérotée 1085
Cours du CNED (contrôle de conformité, section 5.2.2) 1086

Fiche de révision et fiches-outils 1088
Fiche de révision du chapitre 5 1089
Fiches-outils du chapitre 5 1091

Cahier d'exercices 1095
Partie 1 – Définir la littératie en santé et la littératie alimentaire 1099
Partie 2 – Les données françaises et les enjeux pour la santé publique 1115
Partie 3 – Repérer sans stigmatiser et adapter le diagnostic 1129
Partie 4 – Écrire clair, FALC et mesure de la lisibilité 1142
Partie 5 – Vérifier la compréhension et animer un atelier accessible 1157
Partie 6 – Lire une étiquette et comprendre les chiffres : littératie alimentaire et numératie 1170
Partie 7 – Numérique, langues et handicaps : rendre l'information accessible 1185
Partie 8 – Outils pédagogiques, littératie dans le projet et cas complet 1201
Bilan : grille d'auto-évaluation 1216

Annales E5 1218
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 1220
S1 – « Les papiers, c'est ma fille qui les lit » : littératie en santé sur deux aires d'accueil des gens du voyage 1220
S2 – « Cuisiner pour apprendre le français » : un atelier avec un groupe d'apprenants en ateliers sociolinguistiques 1224
S3 – « Voir avec les mains » : alimentation, information et autonomie de personnes déficientes visuelles 1227
Partie II – Les corrigés détaillés 1231
Corrigé S1 – « Les papiers, c'est ma fille qui les lit » : littératie en santé sur deux aires d'accueil des gens du voyage 1231
Corrigé S2 – « Cuisiner pour apprendre le français » : un atelier avec un groupe d'apprenants en ateliers sociolinguistiques 1237
Corrigé S3 – « Voir avec les mains » : alimentation, information et autonomie de personnes déficientes visuelles 1242
Grille d'auto-évaluation 1249

Chapitre 6 · Éthique et déontologie en santé publique 1250

Cours 1254
6.1 Compétences mobilisées 1255
6.2 Croisement référentiel × précisions × indications 1255
6.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 1256
6.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 1256
6.3 Cours 1257
6.3.1 Morale, éthique, déontologie, droit 1257
6.3.2 Les principes éthiques 1261
6.3.3 Le cadre professionnel du diététicien 1269
6.3.4 Le secret professionnel et la confidentialité 1273
6.3.5 La protection des données personnelles (RGPD) 1277
6.3.6 Le consentement et le droit à l'image 1283
6.3.7 Les conflits d'intérêts 1287
6.3.8 Une démarche de réflexion éthique 1290
6.3.9 Les droits des usagers et la démocratie en santé 1294
6.3.10 La responsabilité du professionnel dans une action collective 1299
6.3.11 Publicité, allégations et compléments alimentaires : repères pour une information loyale 1303
6.3.12 Enquêtes, recherche et protection des personnes 1308

6.3.13 Identité numérique et e-réputation du professionnel 1312
6.3.14 Cinq dilemmes éthiques commentés 1314
6.3.15 Laïcité et neutralité dans les actions de santé publique 1317
6.3.16 Fil rouge : les choix éthiques d'Inès 1319
6.3.17 Cas guidé : repérer la dénutrition des seniors à domicile 1319
6.4 Approfondissements 1321
6.4.1 Le diététicien sur les réseaux sociaux 1321
6.4.2 Les partenariats public-privé en nutrition 1322
6.4.3 La participation des personnes : une exigence éthique 1324
6.4.4 Éthique et intelligence artificielle en santé 1325
6.4.5 Le consentement des personnes vulnérables 1326
6.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 1328
6.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 1329
Méthodes pour l'épreuve E5 : réussir les questions d'éthique 1330
Méthode 5 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve 1331
Méthode 6 – Relier l'éthique aux autres chapitres du cours 1332
Méthode 7 – Savoir à qui s'adresser : les autorités et leurs rôles 1333
6.7 L'essentiel à retenir 1334
6.8 Entraînement 1335
6.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 1335
6.8.2 Exercices 1337
6.8.3 Questions de réflexion 1340
6.8.4 Étude de cas 1341
6.8.5 Mises en situation express 1341
6.8.6 Exercices complémentaires 1344
6.9 Glossaire 1345
6.10 Renvois bibliographiques par notion 1346
6.12 Bibliographie numérotée 1346
Cours du CNED (contrôle de conformité, section 6.2.2) 1347

Fiche de révision et fiches-outils 1349
Fiche de révision du chapitre 6 1350
Fiches-outils du chapitre 6 1352

Cahier d'exercices 1356
Partie 1 – Les fondements : éthique, principes et stigmatisation 1360
Partie 2 – Le cadre professionnel et le secret 1373
Partie 3 – Protéger les données personnelles (RGPD) 1389
Partie 4 – Le consentement et le droit à l'image 1404
Partie 5 – Conflits d'intérêts et partenariats 1418
Partie 6 – Allégations, publicité et compléments alimentaires 1431
Partie 7 – Enquêtes, recherche et identité numérique 1447
Partie 8 – Synthèse : droits, responsabilité, dignité et cas complet 1460
Bilan : grille d'auto-évaluation 1475

Annales E5 1477
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 1480
S1 – « Je préfère sauter le repas plutôt que d'en parler » : une enquête sur l'insécurité alimentaire étudiante et ses enjeux… 1480
S2 – « Cuisiner sans alcool, et sans être jugé » : un atelier culinaire en soins de réadaptation en addictologie 1484
S3 – « Mon coach dit que sans poudre, je ne prendrai jamais de muscle » : compléments alimentaires, influence et éthiqu… 1488
Partie II – Les corrigés détaillés 1493
Corrigé S1 – « Je préfère sauter le repas plutôt que d'en parler » : une enquête sur l'insécurité alimentaire étudiante et se… 1493
Corrigé S2 – « Cuisiner sans alcool, et sans être jugé » : un atelier culinaire en soins de réadaptation en addictologie 1500
Corrigé S3 – « Mon coach dit que sans poudre, je ne prendrai jamais de muscle » : compléments alimentaires, influence et… 1506
Grille d'auto-évaluation 1513

Chapitre 7 · Démarche de projet (1) : diagnostic, priorités et objectifs 1514

Cours 1518
- 7.1 Compétences mobilisées 1519
- 7.2 Croisement référentiel × précisions × indications 1519
  - 7.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 1520
  - 7.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 1520
- 7.3 Cours 1521
  - 7.3.1 Qu'est-ce qu'un projet de santé publique ? 1521
  - 7.3.2 L'analyse de situation 1527
  - 7.3.3 Recueillir des données sur le terrain 1534
  - 7.3.4 Analyser et présenter les données 1542
  - 7.3.5 Poser le diagnostic 1548
  - 7.3.6 Définir les priorités 1554
  - 7.3.7 Rédiger les objectifs 1558
  - 7.3.8 Choisir un échantillon en pratique 1563
  - 7.3.9 Les méthodes participatives de diagnostic 1567
  - 7.3.10 Analyser l'environnement alimentaire d'un territoire 1570
  - 7.3.11 Croiser les données : tableaux à double entrée 1574
  - 7.3.12 Formuler une problématique de projet 1576
  - 7.3.13 Du diagnostic à la stratégie : la matrice FFOM croisée 1579
  - 7.3.14 Fil rouge : le diagnostic d'Inès pas à pas 1581
  - 7.3.15 Rédiger la partie « analyse de situation et diagnostic » d'un dossier 1584
- 7.4 Approfondissements 1585
  - 7.4.1 Le diagnostic local de santé et le contrat local de santé 1585
  - 7.4.2 La participation des habitants au diagnostic 1586
  - 7.4.3 S'appuyer sur les données probantes 1586
  - 7.4.4 Le diagnostic en milieu scolaire, en entreprise et en établissement 1587
  - 7.4.5 Mesurer les inégalités dans le diagnostic 1588
- 7.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 1590
- 7.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 1591
  - Cas guidé : le diagnostic des goûters d'un accueil de loisirs 1591
  - Méthodes pour l'épreuve E5 : réussir les questions de diagnostic 1593
  - Méthode 4 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve 1594
  - Méthode 5 – Relier le diagnostic aux autres chapitres 1595
  - Méthode 6 – Défendre son diagnostic à l'oral 1595
- 7.7 L'essentiel à retenir 1596
- 7.8 Entraînement 1597
  - 7.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 1597
  - 7.8.2 Exercices 1598
  - 7.8.3 Questions de réflexion 1602
  - 7.8.4 Étude de cas 1603
  - 7.8.5 Mises en situation express 1604
  - 7.8.6 Exercices complémentaires 1606
- 7.9 Glossaire 1608
- 7.10 Renvois bibliographiques par notion 1609
- 7.12 Bibliographie numérotée 1610
  - Cours du CNED (contrôle de conformité, section 7.2.2) 1610

Fiche de révision et fiches-outils 1612
- Fiche de révision du chapitre 7 1613
- Fiches-outils du chapitre 7 1615

Cahier d'exercices 1619
- Partie 1 – Le projet et l'analyse de situation 1623
- Partie 2 – Recueillir les données sur le terrain 1639
- Partie 3 – Analyser et présenter les données 1655
- Partie 4 – Échantillonnage et précision 1668
- Partie 5 – Poser le diagnostic 1680

Partie 6 – Définir les priorités ... 1694
Partie 7 – Problématique et objectifs ... 1708
Partie 8 – Synthèse : diagnostic en situation réelle et cas complet ... 1719
Bilan : grille d'auto-évaluation ... 1734

Annales E5 ... **1736**
Partie I – Les sujets (sans corrigé) ... 1738
S1 – « À bord, on mange quand on peut » : le diagnostic de santé nutritionnelle des marins-pêcheurs d'un port artisanal ... 1738
S2 – « Je dois tenir pour lui » : un atelier culinaire pour les parents hébergés près d'un hôpital pédiatrique ... 1742
S3 – « Au camping toute l'année, mais personne ne le sait » : diagnostic participatif et atelier culinaire avec les habitants p... ... 1746
Partie II – Les corrigés détaillés ... 1751
Corrigé S1 – « À bord, on mange quand on peut » : le diagnostic de santé nutritionnelle des marins-pêcheurs d'un port arti... ... 1751
Corrigé S2 – « Je dois tenir pour lui » : un atelier culinaire pour les parents hébergés près d'un hôpital pédiatrique ... 1757
Corrigé S3 – « Au camping toute l'année, mais personne ne le sait » : diagnostic participatif et atelier culinaire avec les hab... ... 1765
Grille d'auto-évaluation ... 1775

Chapitre 8 · Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage 1777

Cours ... **1781**
8.1 Compétences mobilisées ... 1782
8.2 Croisement référentiel × précisions × indications ... 1782
8.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 ... 1783
8.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED ... 1783
8.3 Cours ... 1784
8.3.1 Choisir les stratégies et les actions ... 1784
8.3.2 Les parties prenantes et le partenariat ... 1789
8.3.3 Les financements et les appels à projets ... 1794
8.3.4 Planifier le projet ... 1801
8.3.5 Construire et suivre le budget ... 1807
8.3.6 Piloter le projet ... 1814
8.3.7 Élaborer le plan de communication du projet ... 1819
8.3.8 Choisir les méthodes et les outils pédagogiques ... 1824
8.3.9 Organiser la logistique des ateliers ... 1831
8.3.10 Anticiper la trésorerie du projet ... 1836
8.3.11 Rédiger un dossier de demande de financement : exemple commenté ... 1839
8.3.12 La convention de partenariat : un modèle commenté ... 1840
8.3.13 Estimer la charge de travail et tenir une feuille de temps ... 1843
8.3.14 Utiliser les outils numériques du projet ... 1844
8.3.15 Fil rouge : le plan d'action d'Inès ... 1849
8.4 Approfondissements ... 1850
8.4.1 Le cadre logique, outil des financeurs ... 1850
8.4.2 Le travail en réseau et la coordination territoriale ... 1852
8.4.3 La pérennisation dès la conception ... 1853
8.4.4 Les contrats pluriannuels et les fonds européens ... 1854
8.4.5 La gestion des bénévoles ... 1855
8.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 ... 1856
8.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles ... 1857
Cas guidé : un tiers-lieu nourricier en milieu rural ... 1858
Ce que le jury attend sur la conception et le pilotage ... 1860
8.7 L'essentiel à retenir ... 1861
8.8 Entraînement ... 1862
8.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) ... 1862
8.8.2 Exercices ... 1863
8.8.3 Questions de réflexion ... 1866
8.8.4 Étude de cas ... 1867
8.8.5 Mises en situation express ... 1868
8.8.6 Exercices complémentaires ... 1870
8.9 Glossaire ... 1872
8.10 Renvois bibliographiques par notion ... 1873

8.12 Bibliographie numérotée ... 1873
Cours du CNED (contrôle de conformité, section 8.2.2) ... 1873

Fiche de révision et fiches-outils ... 1875
Fiche de révision du chapitre 8 ... 1876
Fiches-outils du chapitre 8 ... 1878

Cahier d'exercices ... 1881
Partie 1 – Les stratégies, les actions et la fiche action ... 1885
Partie 2 – Les parties prenantes, le partenariat et le pilotage ... 1901
Partie 3 – Les financements et les appels à projets ... 1915
Partie 4 – Planifier le projet ... 1929
Partie 5 – Construire et suivre le budget ... 1942
Partie 6 – La trésorerie, la logistique et les méthodes pédagogiques ... 1954
Partie 7 – Piloter : tableau de bord, risques et communication ... 1966
Partie 8 – Synthèse : du plan d'action au cas complet ... 1980
Bilan : grille d'auto-évaluation ... 1997

Annales E5 ... 1999
Partie I – Les sujets (sans corrigé) ... 2002
S1 – « On cultive des légumes qu'on ne mange pas » : concevoir et piloter un projet alimentation dans un chantier d'insert... ... 2002
S2 – « Mes mains tremblent, mais je veux encore cuisiner » : un atelier culinaire pour des personnes atteintes de la maladi... ... 2006
S3 – « On commence à 5 heures, on mange à 9 heures, et encore » : piloter à mi-parcours un projet pour les agents de pro... ... 2010
Partie II – Les corrigés détaillés ... 2015
Corrigé S1 – « On cultive des légumes qu'on ne mange pas » : concevoir et piloter un projet alimentation dans un chantier... ... 2015
Corrigé S2 – « Mes mains tremblent, mais je veux encore cuisiner » : un atelier culinaire pour des personnes atteintes de l... ... 2022
Corrigé S3 – « On commence à 5 heures, on mange à 9 heures, et encore » : piloter à mi-parcours un projet pour les agent... ... 2028
Grille d'auto-évaluation ... 2035

Chapitre 9 · Démarche de projet (3) : évaluation et valorisation 2036

Cours ... 2040
9.1 Compétences mobilisées ... 2041
9.2 Croisement référentiel × précisions × indications ... 2041
9.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 ... 2042
9.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED ... 2042
9.3 Cours ... 2043
9.3.1 Qu'est-ce qu'évaluer ? ... 2043
9.3.2 Construire les indicateurs ... 2050
9.3.3 Choisir les méthodes et les outils ... 2055
9.3.4 Analyser et interpréter les résultats ... 2061
9.3.5 Valoriser le projet ... 2070
9.3.6 Rédiger les parties « évaluation » et « bilan » d'un dossier ... 2077
9.3.7 Analyser des données avant/après appariées ... 2082
9.3.8 L'évaluation qualitative ... 2085
9.3.9 Évaluer l'animation : observer et s'auto-évaluer ... 2090
9.3.10 Évaluer l'équité et les effets environnementaux ... 2094
9.3.11 Présenter un projet et ses résultats à l'oral ... 2097
9.3.12 Le rapport d'évaluation : un modèle de plan commenté ... 2101
9.3.13 Évaluer à distance : mesurer le maintien des changements ... 2104
9.3.14 Fil rouge : l'évaluation et la valorisation du projet des Tilleuls ... 2106
9.4 Approfondissements ... 2107
9.4.1 L'évaluation participative ... 2107
9.4.2 Les données probantes en prévention ... 2108
9.4.3 Les effets indésirables d'une action de prévention ... 2110
9.4.4 Le coût de l'évaluation et sa proportionnalité ... 2111
9.4.5 Évaluation et apprentissage organisationnel ... 2112
9.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 ... 2113
9.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles ... 2114
Cas guidé : évaluer le défi « Un fruit à la récré » d'une école élémentaire ... 2115

Ce que le jury attend sur l'évaluation et la valorisation 2117
9.7 L'essentiel à retenir 2118
9.8 Entraînement 2119
9.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 2119
9.8.2 Exercices 2120
9.8.3 Questions de réflexion 2123
9.8.4 Étude de cas 2124
9.8.5 Mises en situation express 2125
9.8.6 Exercices complémentaires 2127
9.9 Glossaire 2129
9.10 Renvois bibliographiques par notion 2130
9.12 Bibliographie numérotée 2131
Cours du CNED (contrôle de conformité, section 9.2.2) 2131

Fiche de révision et fiches-outils 2133
Fiche de révision du chapitre 9 2134
Fiches-outils du chapitre 9 2136

Cahier d'exercices 2139
Partie 1 – Évaluer : finalités, moments, critères 2143
Partie 2 – Les indicateurs et le plan d'évaluation 2158
Partie 3 – Les méthodes et les outils de recueil 2174
Partie 4 – Les calculs d'évaluation 2189
Partie 5 – Interpréter et juger 2201
Partie 6 – L'évaluation qualitative 2217
Partie 7 – Valoriser et rendre compte 2231
Partie 8 – Décider, transférer et s'entraîner sur un cas complet 2245
Bilan : grille d'auto-évaluation 2264

Annales E5 2266
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 2269
S1 – « Avant, je cuisinais pour toute la famille ; ici, je mange du pain et du fromage » : évaluer et valoriser un projet dans u… 2269
S2 – « Ma gamelle, c'est moi qui la fais » : un atelier culinaire pour des travailleurs d'un ESAT, et son évaluation 2273
S3 – « Le bip sonne toujours quand on passe à table » : évaluer un projet dans un centre de secours, le faire adopter, et an… 2278
Partie II – Les corrigés détaillés 2284
Corrigé S1 – « Avant, je cuisinais pour toute la famille ; ici, je mange du pain et du fromage » : évaluer et valoriser un proje… 2284
Corrigé S2 – « Ma gamelle, c'est moi qui la fais » : un atelier culinaire pour des travailleurs d'un ESAT, et son évaluation 2290
Corrigé S3 – « Le bip sonne toujours quand on passe à table » : évaluer un projet dans un centre de secours, le faire adopt… 2296
Grille d'auto-évaluation 2303

DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE

CHAPITRE 1

La santé publique et la promotion de la santé en nutrition

Mots-clés : Santé publique, Promotion de la santé, Politiques nutritionnelles

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 1 · La santé publique et la promotion de la santé en nutrition · version normale

1

COURS

Mise en page normale · 96 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 5 à 100

2

FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 10 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 101 à 110

3

CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 93 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 111 à 203

4

ANNALES E5

Mise en page normale · 27 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 204 à 230

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 • Cours **5**

1.1 Compétences mobilisées 7
1.2 Croisement référentiel × précisions × indications 8
1.3 Cours 10
1.4 Approfondissements 74
1.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 78
1.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 79
1.7 L'essentiel à retenir 81
1.8 Entraînement 83
1.9 Glossaire 96
1.10 Renvois bibliographiques par notion 98
1.12 Bibliographie numérotée 98

2 • Fiche de révision et fiches-outils **101**

Fiche de révision du chapitre 1 103
1. Les définitions à savoir par cœur 103
2. Les classifications à ne pas confondre 104
3. La Charte d'Ottawa : 5 + 3 104
4. Les dates et textes à jour (octobre 2026) 104
5. Chiffres-clés 105
6. Les pièges classiques 105
7. Méthode express pour l'oral E5 : qualifier son action en 4 phrases 105
8. Auto-test (réponses en bas de page) 105
9. Flashcards à découper 106

Fiches-outils du chapitre 1 106
O1.1 – Qualifier mon action 107
O1.2 – Portrait express de mon territoire 107
O1.3 – Carte des acteurs de mon territoire 108
O1.4 – Inscrire mon projet dans les politiques en vigueur 108
O1.5 – Analyser un projet avec la Charte d'Ottawa 109
O1.6 – Les déterminants de l'alimentation de mon public 109
O1.7 – Tableau de veille des politiques nutritionnelles 110
O1.8 – Check-list éthique et non-stigmatisation d'un message ou d'un support 110

3 • Cahier d'exercices **111**

Cahier d'exercices – Chapitre 1 114
Partie 1 – Les concepts de santé 115
Partie 2 – La santé publique : définitions, missions et approche populationnelle 126
Partie 3 – Problème de santé, danger, risque, facteurs de risque et de protection 138
Partie 4 – Les modes d'intervention en santé publique 148
Partie 5 – Les acteurs et les organismes de la santé publique en nutrition 159
Partie 6 – Les politiques publiques de santé et leur déclinaison territoriale 170
Partie 7 – Les politiques nutritionnelles de santé publique 181
Partie 8 – Le diététicien-nutritionniste en santé publique et la démarche de projet 191
Bilan : grille d'auto-évaluation 203

4 • Annales E5 ..... **204**

Cahier d'annales E5 – chapitre 1 206
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 207
Partie II – Les corrigés détaillés 215
Grille d'auto-évaluation 230

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS

CHAPITRE

01

La santé publique et la promotion de la santé en nutrition

Santé publique | Promotion de la santé | Politiques nutritionnelles

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

1.1 Compétences mobilisées 7

1.2 Croisement référentiel × précisions × indications 8

1.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 8

1.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 9

1.3 Cours 10

1.3.1 Les concepts de santé : du modèle biomédical à « Une seule santé » 10

1.3.2 La santé publique : définitions, missions et approche populationnelle 16

1.3.3 Problème de santé, danger, risque, facteur de risque et facteur de protection 22

1.3.4 Les modes d'intervention en santé publique 24

1.3.5 Les acteurs et les organismes de la santé publique en nutrition 35

1.3.6 Les politiques publiques de santé : élaboration, pilotage, mise en œuvre et déclinaison territoriale 43

1.3.7 Les politiques nutritionnelles de santé publique 49

1.3.8 Le diététicien-nutritionniste en santé publique 56

1.3.9 Fil rouge : le projet « Bien manger, petit budget, grand plaisir » du centre social des Tilleuls 58

1.4 Approfondissements 74

1.4.1 Les données probantes en promotion de la santé 74

1.4.2 Les théories du changement de comportement : premier aperçu 75

1.4.3 Le débat sur les aliments ultra-transformés 75

1.4.4 Promotion de la santé et non-stigmatisation du poids 76

1.4.5 Santé publique, alimentation et climat 77

1.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 78

1.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 79

Méthode 1 – Présenter le cadre de son action en deux minutes (oral E5) 80

Méthode 2 – Lire de façon critique un document de santé publique 81

1.7 L'essentiel à retenir 81

1.8 Entraînement 83

1.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 83

1.8.2 Exercices 85

1.8.3 Questions de réflexion 90

1.8.4 Étude de cas 92

1.8.5 Mises en situation express 92

1.9 Glossaire 96

1.10 Renvois bibliographiques par notion 98

1.12 Bibliographie numérotée 98

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- définir la santé selon différents modèles (biomédical, OMS 1946, biopsychosocial, santé globale, « Une seule santé / One Health ») et expliquer leurs conséquences pour l'action du diététicien ;
- définir la santé publique, ses missions et son approche populationnelle, et situer les activités du diététicien dans le cadre institutionnel et politique (objectif du guide 2025) ;
- distinguer problème de santé, danger, risque, facteur de risque et facteur de protection ;
- distinguer les modes d'intervention en santé publique : surveillance et veille sanitaire, promotion de la santé, prévention (primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire ; universelle, sélective, indiquée), éducation pour la santé (nutritionnelle, alimentaire, sensorielle), et les différencier de l'éducation thérapeutique du patient (BC1) ;
- citer les cinq axes et les trois stratégies de la Charte d'Ottawa (1986) et les illustrer en nutrition ;
- identifier les acteurs et les organismes de la santé publique en nutrition, et ceux qui recueillent et produisent des données ;
- expliquer comment une politique publique de santé est élaborée, pilotée et mise en œuvre, et comment elle est déclinée sur un territoire (ARS, PRS, CLS, PAT) ;
- présenter les politiques nutritionnelles en vigueur au 26 octobre 2026 (SNANC 2025-2030, PNNS 5 2026-2030, PNA 4, EGalim, Nutri-Score, repères alimentaires) et leur histoire ;
- relier ces notions à un projet réel (cas fil rouge) en utilisant les fiches-outils F1 à F14.

1.1 Compétences mobilisées

Ce chapitre est le **socle** de tout le BC3 : il donne le vocabulaire et le cadre institutionnel dans lesquels s'inscrivent les autres chapitres.

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.1	Concepts, modes d'intervention, politiques et acteurs pour poser un diagnostic, justifier des priorités et des objectifs, choisir le bon type d'action	Analyse et diagnostic de situation posé ; priorités et objectifs adaptés au contexte ; règles éthiques, juridiques et déontologiques respectées
C3.2	Inscrire l'atelier culinaire dans un projet d'éducation pour la santé (éducation alimentaire et sensorielle)	Besoins, objectifs et spécificités du public identifiés
C3.3	Connaître les organismes producteurs de données et les grandes enquêtes	Contexte et problématique de l'étude identifiés
C3.4	Identifier les textes de référence à jour (SNANC, PNNS 5, PNA 4) et les sources institutionnelles fiables	Sources d'informations fiables repérées et connues
C3.5	Adapter le discours au public selon la démarche de promotion de la santé (pouvoir d'agir, non-stigmatisation)	Supports et contenus adaptés au public

1.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (référentiel et guide)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Concepts de santé	Définir la santé (OMS 1946) ; comparer les modèles biomédical, biopsychosocial, global ; expliquer « Une seule santé »	Citer la définition de l'OMS mot pour mot ; pas d'histoire détaillée de la médecine
Santé publique : définition et missions	Définir la santé publique ; citer ses missions ; expliquer l'approche populationnelle	Connaître la définition de Winslow et celle du Code de la santé publique (art. L. 1411-1)
Problèmes de santé : danger, risque, facteur de risque	Distinguer ces notions et les illustrer en nutrition	Les déterminants et leurs niveaux sont développés au chapitre 2
Modes d'intervention : surveillance, veille sanitaire, promotion, prévention, éducation pour la santé (nutritionnelle, alimentaire, sensorielle)	Distinguer et illustrer chaque mode ; classer une action ; distinguer éducation pour la santé et ETP	Classifications de l'OMS (1948) et de Gordon (1983) exigibles ; Charte d'Ottawa : 5 axes + 3 stratégies
Organismes de recueil et de production de données	Citer les principaux organismes et leur rôle	Les études elles-mêmes (INCA, ESTEBAN, NutriNet-Santé) sont détaillées au chapitre 17
Politiques publiques de santé : élaboration, pilotage, mise en œuvre	Décrire le circuit d'une politique (loi, stratégie, plan, programme)	Pas de droit constitutionnel ; connaître SNS, ARS, PRS, CLS
Politiques nutritionnelles de santé publique	Présenter le PNNS (historique, PNNS 5), la SNANC, le PNA, EGalim, le Nutri-Score, les repères	Le guide 2025 recommande de s'appuyer sur le PNNS ; utiliser la version en vigueur (PNNS 5)
Déclinaison territoriale	Expliquer le rôle de l'ARS, du PRS, des CLS, des PAT, des contrats de ville	Savoir où trouver ces documents pour son lieu de stage

1.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : bloc 3, savoirs « Enjeux de santé publique ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 60). Toutes les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des textes au 26 octobre 2026 ; les corrections sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 1.2.2.

Texte	Critère ou indication	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 60	Concepts de santé ; danger, risque, facteur de risque ; mesure de l'état de santé ; santé publique ; modes d'intervention ; organismes producteurs de données ; politiques de santé et politiques nutritionnelles (s'appuyer sur le PNNS) ; déclinaison territoriale	1.3.1 à 1.3.7, dans l'ordre du guide (voir le tableau 1.2) ; définitions et calculs des indicateurs et des déterminants au chapitre 2
Référentiel, C3.1	Analyse et diagnostic de situation ; priorités et objectifs adaptés ; règles éthiques, juridiques et déontologiques	1.3.9 (fil rouge) ; 1.6 ; méthodes de présentation du cadre
Référentiel, C3.4	Sources d'informations fiables repérées et connues	1.3.5, 1.3.7 et 1.10 (sources datées, textes en vigueur)
Référentiel, C3.5	Supports et contenus adaptés au public	1.4.4 (non-stigmatisation du poids) ; 1.3.4 (approches éducatives)
Référentiel, activité 3.1	Contexte institutionnel ; données sur le territoire et les déterminants	1.3.5 et 1.3.6 ; le détail des déterminants est au chapitre 2

1.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié par rapport aux fascicules du CNED qui traitent de la santé publique :

- *Environnement professionnel – Les essentiels*, 2e année (CNED 3-6124-AN-WT-00-21, © 2022), module 1, séquences 1 « Notion de santé » (p. 3 à 7), 2 « Outils, ressources et méthodologies en santé publique » (p. 8 à 12) et 3 « Politique de santé, pilotage et mise en œuvre » (p. 13 à 16) ;
- *Environnement professionnel – Synthèse du cours en bref*, 1re année (CNED 3-6123-AN-WT-00-21), module 3 « Santé, politique de santé, système de santé (1re partie) » (p. 25 à 30), pour le passage sur le Nutri-Score.

Toutes les notions de ces passages sont reprises. Les autres parties de ces séquences sont traitées aux chapitres 2, 3, 5 et 17.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Essentiels M1 S1 §1 (p. 3)	Définition de la santé de l'OMS (1946) ; exemples de l'alimentation et du sport ; santé « notion relative », « état dynamique »	1.3.1 (définition, critiques, santé relative et dynamique)
Essentiels M1 S1 §2 (p. 3)	Définition de la santé publique attribuée à l'OMS (1952) et cinq moyens d'action collective	1.3.2 (définition de Winslow et missions)
Essentiels M1 S1 §3 (p. 4)	Évolution historique de la santé publique, de l'Antiquité au XXIe siècle	1.3.2 (brève histoire de la santé publique, frise)
Essentiels M1 S1 §4 (p. 5 et 6)	« Risque sanitaire » ; veille et sécurité sanitaire ; prévention primaire, secondaire, tertiaire (OMS) ; promotion de la santé ; éducation pour la santé et ETP ; restauration de la santé	1.3.3 (risque) ; 1.3.4 (modes d'intervention, sécurité sanitaire et restauration de la santé, ETP)
Essentiels M1 S2 §1.1 (p. 8)	Organismes en charge des données : INDS et SNDS, ANSES, EFSA	1.3.5 (ANSES, EFSA) ; 1.3.6 (données qui éclairent les politiques, Plateforme des données de santé)
Essentiels M1 S3 §1.1 et §1.2 (p. 13 et 14)	Politique de santé publique ; quatre types d'acteurs (consultatifs, décideurs, opérationnels, financeurs) ; priorité sanitaire, programme, planification	1.3.5 (typologie des acteurs) ; 1.3.6 (priorités, programmes et planification)
Essentiels M1 S3 §1.3 et §1.4 (p. 14 et 15)	Durée des plans ; niveaux régional, national, européen, mondial ; ARS ; HCSP, CNS, CNA	1.3.5 (acteurs par niveau) ; 1.3.6 (PRS, déclinaison territoriale)
Essentiels M1 S3 §1.5 (p. 15)	Démocratie sanitaire : loi du 4 mars 2002, droits individuels et collectifs	1.3.5 (la démocratie sanitaire : la place des usagers)
Essentiels M1 S3 §1.6 (p. 15 et 16)	L'OMS, fondée en 1948 : missions	1.3.5 (niveau international)
Essentiels M1 S3 §2 et §3 (p. 16)	Stratégie nationale de santé 2018-2022 ; planification sanitaire ; rôle de l'État et de l'ARS	1.3.6 (stratégie nationale de santé, planification descendante et ascendante)
Synthèse 1re année M3 S1 §2 (p. 29)	Information nutritionnelle : étiquetage (règlement de 2011) et Nutri-Score prévu par la loi de 2016	1.3.7 (frise des politiques nutritionnelles, Nutri-Score)

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou était inexact

- **Définition de la santé** (p. 3) : le fascicule écrit « bien-être physique, social et mental » et « l'absence de maladie ». Le texte exact de la Constitution de l'OMS est : « un état de complet bien-être physique,

mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». À l'examen, on cite le texte exact.

- **Définition de la santé publique** (p. 3) : elle est de **Charles-Edward A. Winslow (1920)** ; le comité d'experts de l'OMS l'a reprise en 1952. On la présente donc comme la définition de Winslow, reprise par l'OMS.
- **Veille sanitaire** (p. 5) : elle n'est pas « propre à chaque département ». Elle est organisée au niveau national par **Santé publique France**, avec des cellules régionales, et les ARS reçoivent les signalements.
- **Prévention primaire** (p. 5) : elle ne se limite pas à « informer la population ». Elle agit aussi sur l'environnement (offre alimentaire, réglementation) et sur les compétences des personnes.
- **INDS et CNAMTS** (p. 8) : l'Institut national des données de santé a été remplacé en 2019 par la **Plateforme des données de santé (Health Data Hub)** (loi du 24 juillet 2019). La CNAMTS s'appelle aujourd'hui la **Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM)**.
- **HCSP** (p. 15) : le sigle désigne le **Haut Conseil de la santé publique**, créé par la loi du 9 août 2004 (et non le « Haut Comité »). Il n'existe pas de « CNSP » : seule la **Conférence nationale de santé (CNS)** existe au niveau national.
- **CRAS** (p. 14) : depuis la loi HPST de 2009, l'instance régionale est la **Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA)**. Les « territoires de santé » sont devenus, avec la loi du 26 janvier 2016, les **territoires de démocratie sanitaire**.
- **Stratégie nationale de santé** (p. 16) : la SNS 2018-2022 reste la dernière adoptée. Le projet de **SNS 2023-2033**, soumis à consultation à l'automne 2023, n'était **pas encore adopté** selon une réponse du ministère publiée le 12 mai 2026. Les textes nutritionnels en vigueur sont la **SNANC 2025-2030** (publiée le 11 février 2026), le **PNNS 5 (2026-2030)** et le **PNA 4 (2026-2030)**, lancés le 8 avril 2026.
- **Nom du ministère** (p. 16) : il change avec les gouvernements ; on écrit « ministère chargé de la santé ».
- **Nutri-Score** (1re année, p. 29) : la loi du 26 janvier 2016 a prévu un logo nutritionnel facultatif ; le **Nutri-Score** a été choisi par l'**arrêté du 31 octobre 2017**, et son algorithme a été révisé par l'**arrêté du 14 mars 2025**.

1.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

1.3.1 Les concepts de santé : du modèle biomédical à « Une seule santé »

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §1 (p. 3)

Le mot « santé » paraît simple ; il recouvre pourtant des conceptions très différentes, qui changent la façon d'agir. Un diététicien qui pense que la santé est seulement « l'absence de maladie » limitera son action aux personnes malades ; s'il considère que la santé est une **ressource** qui dépend des conditions de vie, il agira aussi sur l'environnement alimentaire d'un quartier, sur les menus d'une école ou sur le pouvoir d'agir des habitants.

Le modèle biomédical

Dominant du XIXe siècle au milieu du XXe siècle, le **modèle biomédical** définit la santé de façon **négative** : être en bonne santé, c'est ne pas être malade. La maladie est expliquée par une cause biologique (microbe, lésion d'organe), diagnostiquée et traitée par le médecin. Ce modèle a permis des progrès considérables (vaccins, antibiotiques, chirurgie), mais il ignore le vécu de la personne et les causes sociales des maladies. Appliqué à la nutrition, il conduit à ne voir dans l'obésité qu'un déséquilibre entre apports et dépenses énergétiques, sans tenir compte du revenu, du stress, de l'offre alimentaire ou du marketing.

La définition de l'Organisation mondiale de la santé (1946)

Définition – La santé selon l'OMS

> « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » Préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, adoptée par la Conférence internationale de la santé à New York (19 juin – 22 juillet 1946), signée le 22 juillet 1946 et entrée en vigueur le 7 avril 1948 (date devenue la Journée mondiale de la santé). Cette définition n'a pas été modifiée depuis.

Cette définition est **révolutionnaire** pour trois raisons : elle est **positive** (la santé est un état de bien-être, pas seulement l'absence de maladie) ; elle est **multidimensionnelle** (physique, mentale, sociale) ; elle fait de la santé un **droit** : la Constitution affirme que « la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale ».

Attention – Les critiques de la définition de l'OMS

- Le « complet » bien-être est un **idéal** presque inatteignable : avec cette définition, presque personne n'est en bonne santé, notamment les personnes vivant avec une maladie chronique (diabète, maladie cœliaque) qui peuvent pourtant mener une vie pleinement satisfaisante.
- Elle décrit un **état** figé, alors que la santé est un **équilibre dynamique**.
- Elle ne dit rien de la **capacité d'adaptation** de la personne. D'où la proposition de Machteld Huber et coll. (*BMJ*, 2011) : la santé comme « capacité à s'adapter et à se prendre en charge face aux défis sociaux, physiques et émotionnels ».

Le modèle biopsychosocial et la santé comme ressource

En 1977, le psychiatre George Engel propose le **modèle biopsychosocial** : la santé et la maladie résultent de l'interaction de facteurs **biologiques** (génétique, physiologie), **psychologiques** (émotions, représentations, stress) et **sociaux** (revenu, travail, culture, entourage). En 1986, la **Charte d'Ottawa** prolonge cette vision : la santé est « une **ressource de la vie quotidienne**, et non le but de la vie » ; c'est « un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et personnelles, et les capacités physiques ». Pour l'atteindre, il faut des **conditions préalables** : la paix, un abri, l'éducation, la nourriture, un revenu, un écosystème stable, des ressources durables, la justice sociale et l'équité.

Lien diététique – Ce que cela change pour le diététicien

Dans le modèle biopsychosocial, une consultation ou un atelier ne peut pas se limiter à « donner des conseils ». Une mère de famille qui sert des boissons sucrées au goûter n'ignore pas forcément qu'elles sont trop sucrées : son choix peut s'expliquer par le prix, la demande des enfants, la publicité, la peur que l'enfant « ne mange rien », ou une habitude culturelle. Le diététicien doit **explorer ces dimensions** avant de proposer une action (chapitres 3 et 4).

Santé perçue, santé objective, santé positive

On distingue la **santé objective**, mesurée par des indicateurs (IMC, glycémie, mortalité) et la **santé perçue**, déclarée par la personne (« Comment jugez-vous votre état de santé ? »). La santé perçue est un indicateur utilisé en santé publique (Baromètre de Santé publique France, enquête européenne EHIS) : elle prédit la mortalité indépendamment des indicateurs médicaux. La **santé positive** (bien-être, qualité de vie, santé mentale positive) est valorisée par la promotion de la santé.

La santé globale et l'approche « Une seule santé / One Health »

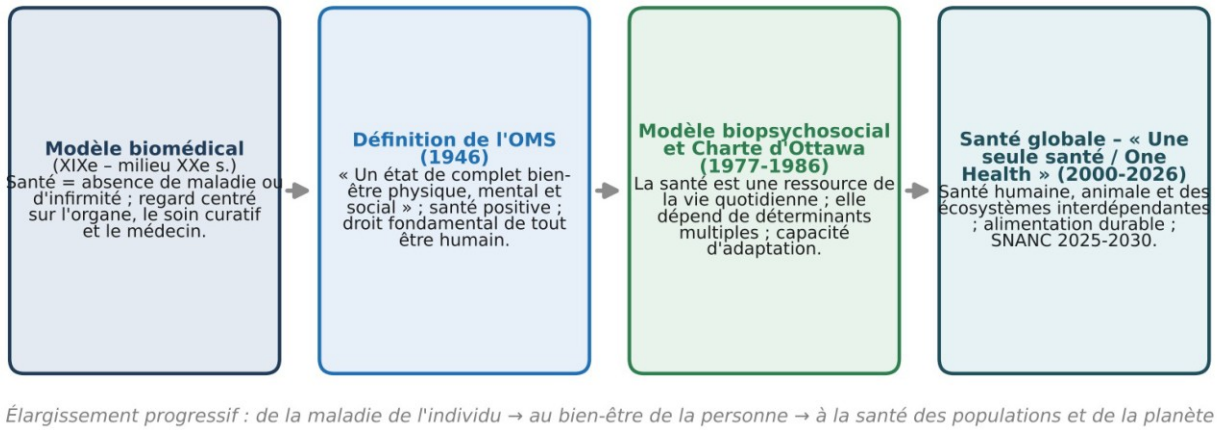


Figure 1.1 – Évolution des concepts de santé

Comprendre le schéma – Figure 1.1

1. Modèle biomédical : la santé est définie négativement, par l'absence de maladie ; l'action est curative et individuelle.

2. Définition de l'OMS (1946) : la santé devient positive (bien-être), multidimensionnelle (physique, mentale, sociale) et un droit fondamental.

3. Modèle biopsychosocial (Engel, 1977) et Charte d'Ottawa (1986) : la santé est une ressource de la vie quotidienne, influencée par de nombreux déterminants ; l'action vise aussi les conditions de vie.

4. Santé globale et « Une seule santé » : la santé humaine est indissociable de la santé animale et de celle des écosystèmes ; l'alimentation durable est au carrefour des trois.

5. La flèche du bas résume le mouvement : on passe de l'individu malade à la population, puis à la planète.

Le concept **« Une seule santé » (One Health)** est né au début des années 2000 (principes de Manhattan, 2004) à partir d'un constat : environ 60 % des maladies infectieuses humaines sont d'origine animale (zoonoses), la résistance aux antibiotiques circule entre élevage, environnement et humains, et le changement climatique modifie la production alimentaire. En 2022, l'OMS, la FAO, l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) et le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), réunis en **« Quadripartite »**, ont adopté un plan d'action conjoint One Health (2022-2026) et une définition commune.

Définition – Une seule santé (One Health) – définition du panel d'experts OHHLEP, 2021, adoptée par la Quadripartite « Une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Elle reconnaît que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l'environnement au sens large (y compris les écosystèmes) est étroitement liée et interdépendante. »

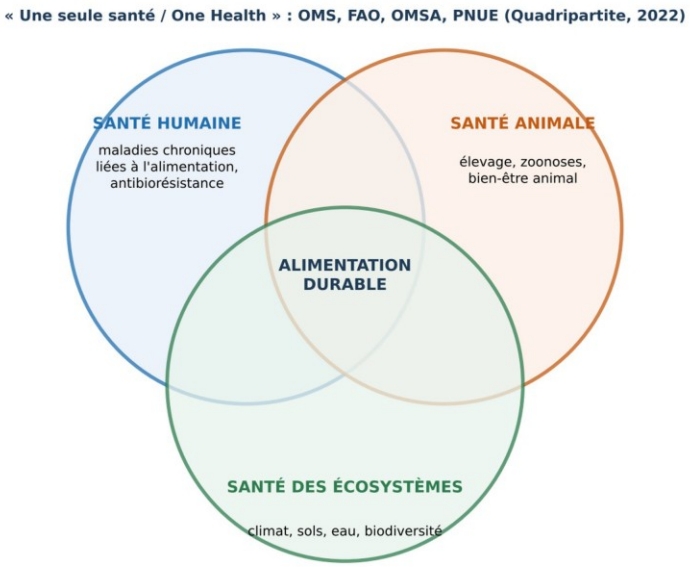


Figure 1.2 – « Une seule santé » : l'alimentation durable au carrefour de trois santés

Comprendre le schéma – Figure 1.2

1. Le cercle bleu représente la **santé humaine** : maladies chroniques liées à l'alimentation (obésité, diabète, cancers), carences, résistance aux antibiotiques.
2. Le cercle orange représente la **santé animale** : conditions d'élevage, bien-être animal, maladies transmissibles à l'humain (zoonoses), usage des antibiotiques en élevage.
3. Le cercle vert représente la **santé des écosystèmes** : climat, qualité des sols et de l'eau, biodiversité, contamination par les pesticides.
4. Les zones de chevauchement montrent les **interdépendances** ; au centre, l'**alimentation durable** agit sur les trois à la fois (par exemple, manger plus de légumineuses et moins de viande améliore la santé humaine, réduit les émissions de gaz à effet de serre et la pression sur les élevages).

Le guide d'accompagnement du BTS (2025) place explicitement **toute intervention en santé publique en nutrition** dans cette approche pluridisciplinaire de l'**alimentation globale « Une seule santé »**. En France, la **SNANC 2025-2030** relie santé publique, transition écologique et souveraineté alimentaire, et le PNNS 5 et le PNA 4 ont été lancés le 8 avril 2026, à l'occasion du **One Health Summit** organisé à Lyon du 5 au 7 avril 2026.

Exemple – Une action de nutrition lue avec les lunettes « Une seule santé »

Une école élémentaire remplace une fois par semaine le plat carné par un plat à base de légumineuses (obligation de la loi EGalim d'un menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire). **Santé humaine** : plus de fibres, moins d'acides gras saturés. **Santé des écosystèmes** : moins d'émissions de gaz à effet de serre (les légumineuses fixent l'azote de l'air et émettent beaucoup moins que la viande de bœuf). **Santé animale** : moindre pression sur l'élevage intensif. Le rôle du diététicien : garantir l'équilibre nutritionnel (apport en protéines, en fer), l'acceptabilité (recettes appréciées des enfants) et la lutte contre le gaspillage.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.1

Classez chacune de ces affirmations dans le modèle qu'elle illustre (biomédical, OMS 1946, biopsychosocial/Ottawa, One Health) : **a)** « Monsieur D. est en bonne santé puisque ses analyses sont normales. » **b)** « La réduction des antibiotiques en élevage protège aussi l'efficacité des traitements chez l'humain. » **c)** « Madame K. a un diabète bien équilibré, travaille, fait du sport et se sent bien : elle s'estime en bonne santé. » **d)** « Pour être en bonne santé, il faut un logement, un revenu et l'accès à une alimentation de qualité. »

Corrigé

a) Modèle biomédical : la santé est réduite à des résultats biologiques normaux, sans prise en compte du vécu. **b) One Health** : lien entre santé animale (usage d'antibiotiques en élevage), environnement (diffusion des bactéries résistantes) et santé humaine. **c) Modèle biopsychosocial / santé comme capacité d'adaptation** : malgré une maladie chronique, la personne a une bonne santé perçue et fonctionnelle ; la définition de l'OMS (« complet » bien-être) l'exclurait, ce qui montre sa limite. **d) Charte d'Ottawa** : ce sont les « conditions préalables à la santé » (abri, revenu, nourriture…).

La santé, une notion relative et dynamique

Aucune définition ne suffit à dire ce qu'est la santé pour chacun. Les cours du CNED et les manuels de santé publique insistent sur trois idées que le jury attend dans un exposé.

1. La santé est une notion individuelle. Chacun juge sa santé selon ses connaissances, ses expériences, son âge, son sexe et ses attentes. Une personne de 80 ans qui marche avec une canne peut se dire « en bonne santé » ; un sportif de 25 ans peut se dire « en mauvaise santé » après une entorse.

2. La santé est une notion variable. Elle change selon les époques, les cultures, les groupes sociaux et le niveau de développement du pays. Au XIXe siècle, être « bien en chair » était un signe de santé et d'aisance ; aujourd'hui, le surpoids est un facteur de risque. Dans certains groupes, une maladie chronique bien équilibrée n'empêche pas de se dire en bonne santé.

3. La santé est un état dynamique. C'est un équilibre instable et temporaire entre la personne et son environnement. Il faut le reconquérir sans cesse : une rupture (perte d'emploi, deuil, déménagement) peut déséquilibrer l'alimentation, le sommeil et la santé mentale en quelques semaines.

Définition – Deux formules célèbres à connaître

René Leriche (chirurgien, 1936) : « La santé, c'est la vie dans le silence des organes. » C'est une vision biomédicale : on est en bonne santé tant qu'on ne ressent rien.

Georges Canguilhem (philosophe, « Le normal et le pathologique », 1943) : être en bonne santé, c'est pouvoir **tomber malade et s'en relever** ; c'est la capacité de s'adapter et de créer de nouvelles normes de vie. C'est une vision dynamique, proche de la santé « ressource » de la Charte d'Ottawa.

Attention – Une limite de la définition de l'OMS

La définition de 1946 parle d'un « état de complet bien-être ». Ce mot « complet » est souvent critiqué : presque personne n'est en « complet bien-être », et la définition peut faire de chacun un malade. Les approches récentes (santé positive, santé comme capacité d'adaptation) répondent à cette critique. Savoir citer cette limite montre au jury une **analyse critique** (C3.4).

Exemple – La même personne, trois regards sur sa santé

Mme Diallo, 58 ans, a un diabète de type 2 équilibré par un traitement. **Regard biomédical** : elle est malade (pathologie chronique). **Regard de l'OMS** : son bien-être social est bon (associative, entourée), son bien-être mental aussi ; seul le volet physique est touché. **Regard dynamique** : elle a adapté son alimentation et marche chaque jour ; elle se dit « en forme ». Pour le diététicien en santé publique, ce regard dynamique est le plus utile : il s'appuie sur les **ressources** de la personne et non sur ses manques.

Mesurer l'état de santé d'une population : premiers repères

Le guide d'accompagnement 2025 place la **mesure de l'état de santé** dans les « enjeux de santé publique ». Pour savoir si une population est en bonne santé, on utilise des **indicateurs** : des données chiffrées, calculées à date

régulière, qui rendent les situations comparables (natalité, mortalité, mortalité infantile, espérance de vie, prévalence, incidence, indice de développement humain). Ils sont produits par l'Insee, la Drees, Santé publique France ou les observatoires régionaux de la santé. Leurs définitions et leurs calculs sont présentés au chapitre 2.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.1 bis – Santé relative

Citez les trois caractéristiques qui font de la santé une notion relative et illustrez chacune par un exemple lié à l'alimentation.

Corrigé – Exercice 1.1 bis

Individuelle : une personne âgée qui mange avec plaisir malgré une dentition fragile se dit en bonne santé. **Variable** : la minceur valorisée aujourd'hui ne l'était pas au XIXe siècle. **Dynamique** : un étudiant qui quitte le foyer familial peut voir son alimentation se dégrader en quelques semaines, puis la rééquilibrer.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 1.3.1 – Les concepts de santé

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez la définition de la santé de l'OMS (1946) et citez une critique de cette définition.
2. Associez chaque modèle à sa date : modèle biopsychosocial ; Charte d'Ottawa ; constitution de l'OMS. Dates : 1946, 1977, 1986.
3. Vrai ou faux : « Pour le modèle biomédical, une personne diabétique bien équilibrée est en bonne santé. » Justifiez.
4. Expliquez en deux phrases pourquoi la santé est une notion relative et dynamique.
5. Citez les trois santés reliées par l'approche « Une seule santé » et donnez un exemple en alimentation.
6. Citez trois indicateurs de l'état de santé d'une population et deux organismes qui les produisent.

Corrigé – Point d'étape 1.3.1

1. « Un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. » Critique : le mot « complet » rend l'objectif presque inatteignable ; la définition est statique.
2. Modèle biopsychosocial : 1977 (Engel) ; Charte d'Ottawa : 1986 ; constitution de l'OMS : 1946 (en vigueur en 1948).
3. Faux : pour le modèle biomédical, la santé est l'absence de maladie ; la personne a une maladie chronique, elle est donc « malade ». Seules les approches globales et dynamiques permettent de dire qu'elle se sent en bonne santé.
4. Relative : elle dépend de chaque personne (âge, expérience, attentes) et varie selon les époques et les cultures. Dynamique : c'est un équilibre instable avec l'environnement, à reconquérir sans cesse.
5. Santé humaine, santé animale, santé des écosystèmes. Exemple : réduire la viande rouge et diversifier les protéines (légumineuses) est bon pour la santé humaine et réduit l'impact environnemental.
6. Par exemple : taux de mortalité, espérance de vie, prévalence d'une maladie ; Insee, Drees, Santé publique France, observatoires régionaux de la santé.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

1.3.2 La santé publique : définitions, missions et approche populationnelle

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §2 (p. 3) ; Essentiels M1 S1 §3 (p. 4)

Définitions

Définition – Santé publique – définition de C.-E. A. Winslow (1920)

« La santé publique est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et de promouvoir la santé et l'efficacité physiques à travers les efforts coordonnés de la communauté pour l'assainissement de l'environnement, le contrôle des infections dans la population, l'éducation de l'individu aux principes de l'hygiène personnelle, l'organisation des services médicaux et infirmiers pour le diagnostic précoce et le traitement préventif des pathologies, le développement des dispositifs sociaux qui assureront à chacun un niveau de vie adéquat pour le maintien de la santé. »

Cette définition centenaire contient déjà tout : **prévenir**, **promouvoir**, agir **collectivement** (« efforts coordonnés de la communauté ») et agir sur les **conditions de vie** (« niveau de vie adéquat »). On retiendra une formulation courte : la santé publique est l'ensemble des **savoirs, des savoir-faire et des actions organisées** qui visent à **maintenir et améliorer la santé de la population**, en agissant de façon collective sur ses déterminants.

Définition – La politique de santé dans le Code de la santé publique (art. L. 1411-1)

La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. La politique de santé relève de la responsabilité de l'État ; elle tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l'amélioration de l'état de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales et l'égalité entre les femmes et les hommes, et à garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et l'accès effectif de la population à la prévention et aux soins. Elle comprend notamment la surveillance et l'observation de l'état de santé et de ses déterminants, la promotion de la santé, la prévention collective et individuelle, l'organisation des parcours de santé, la sécurité sanitaire, l'information et l'éducation à la santé (article issu de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; formulation résumée).

Définition – Santé publique – définition de l'OMS (1952)

En 1952, le comité d'experts de l'OMS sur l'administration de la santé publique reprend et complète la définition de Winslow : « La santé publique est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité physiques et mentales des individus, par le moyen d'une action collective concertée visant à assainir le milieu, à lutter contre les maladies qui présentent une importance sociale, à enseigner à l'individu les règles de l'hygiène personnelle, à organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies, ainsi qu'à mettre en œuvre des mesures sociales propres à assurer à chaque membre de la collectivité un niveau de vie compatible avec le maintien de la santé. L'objet final est de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité. » (formulation reprise par le CNED, Environnement professionnel)

Méthode – Lire la définition de 1952 avec un regard de diététicien

Ce que dit la définition	Exemple en nutrition aujourd'hui
Assainir le milieu	Qualité de l'eau de boisson ; sécurité sanitaire des aliments ; environnement alimentaire (offre autour des écoles)
Lutter contre les maladies qui ont une importance sociale	Obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, dénutrition de la personne âgée
Enseigner les règles d'hygiène personnelle	Éducation pour la santé : repères du PNNS, ateliers culinaires, hygiène en cuisine

Ce que dit la définition	Exemple en nutrition aujourd'hui
Organiser des services en vue du diagnostic précoce	Repérage du rebond d'adiposité en PMI ; dépistage de la dénutrition en EHPAD
Mesures sociales et niveau de vie	Aide alimentaire, tarification sociale de la cantine, chèques alimentaires, épiceries solidaires
Droit inné à la santé	Lien avec l'équité et la réduction des inégalités sociales de santé

Brève histoire de la santé publique

La santé publique n'est pas née avec l'OMS. Elle s'est construite par étapes, en réponse aux grandes menaces de chaque époque. Connaître cette histoire aide à comprendre pourquoi nos dispositifs actuels sont organisés ainsi.

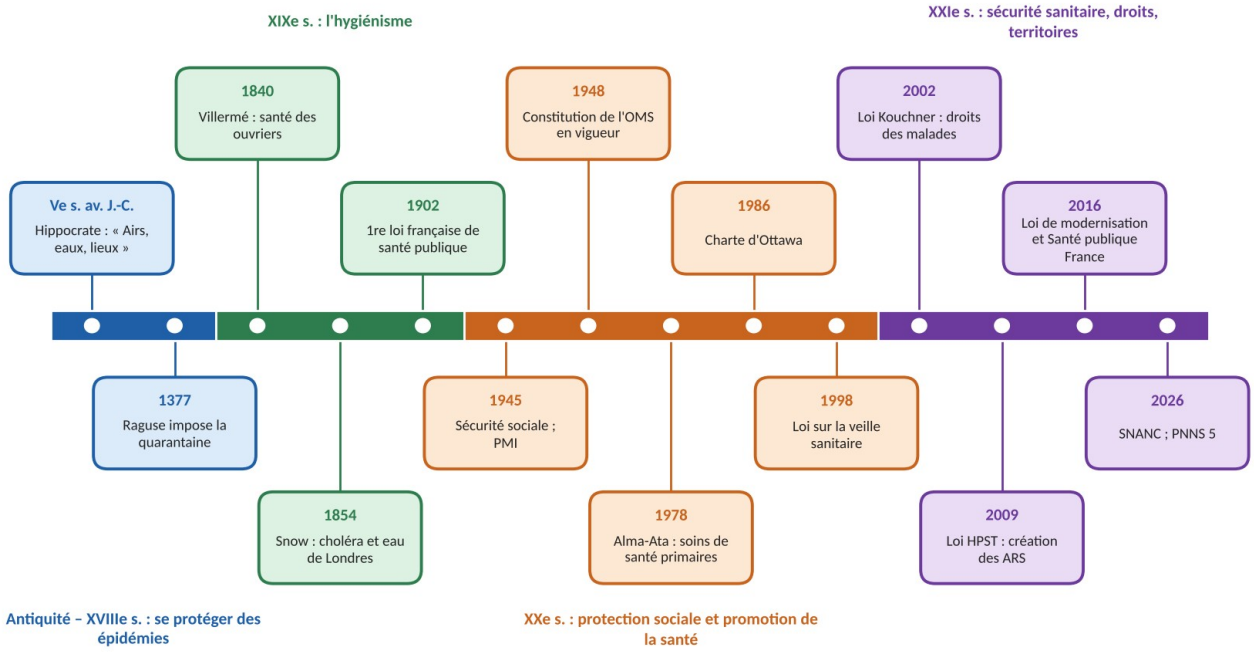


Figure 1.2 bis – Les grandes étapes de la santé publique, de l'Antiquité à aujourd'hui

Comprendre le schéma – Figure 1.2 bis

1. La frise est divisée en **quatre périodes** de couleur : chaque période répond à une préoccupation dominante.
2. **En bleu (Antiquité – XVIIIe siècle)** : on cherche surtout à **éviter la propagation des épidémies** (peste, choléra) par l'isolement et la quarantaine ; Hippocrate relie déjà la santé à l'air, à l'eau et aux lieux.
3. **En vert (XIXe siècle)** : le **mouvement hygiéniste** montre que la misère, le logement insalubre et l'eau polluée tuent ; l'État commence à légiférer (loi de 1902).
4. **En orange (XXe siècle)** : la santé devient un **droit** ; la protection sociale (1945), l'OMS (1948), puis les chartes d'Alma-Ata (1978) et d'Ottawa (1986) élargissent la santé publique à la **promotion de la santé**.
5. **En violet (XXIe siècle)** : après des crises (sang contaminé, vache folle, canicule de 2003, Covid-19), l'accent est mis sur la **sécurité sanitaire**, les **droits des usagers** et l'organisation par **territoires** (ARS).
6. Les dates en orange et en violet sont à connaître pour l'oral : elles permettent de situer le cadre réglementaire d'une action.

Période	Préoccupation dominante	Repères et textes	Ce qu'il en reste en nutrition
Antiquité – Moyen Âge – Renaissance	Survivre aux épidémies dans un contexte de religion toute-puissante, d'instabilité politique et d'absence de médecine curative	Hippocrate (Ve s. av. J.-C.), *Airs, eaux, lieux* ; quarantaine à Raguse (1377) ; lazarets	L'idée que l'environnement fait la santé
XVIIIe siècle	Influence des idées des Lumières et de la Révolution ; la santé du peuple devient l'affaire de l'État	Premières statistiques de population ; vaccination antivariolique (Jenner, 1796)	L'idée de compter pour agir (données)
XIXe siècle	Lutter contre la mortalité ; surveiller les épidémies ; éduquer	Villermé, *Tableau de l'état physique et moral des ouvriers* (1840) ; Snow et le choléra de Londres (1854) ; Pasteur (microbiologie) ; loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique	Hygiène des aliments, eau potable, lait propre pour les nourrissons (« gouttes de lait »)
XXe siècle	Protéger tout le monde ; passer du curatif au préventif puis à la promotion de la santé	Ordonnances de 1945 (Sécurité sociale, PMI) ; OMS (1948) ; Alma-Ata (1978) ; Ottawa (1986) ; loi du 1er juillet 1998 sur la veille sanitaire	PMI, médecine scolaire, premières campagnes d'éducation nutritionnelle
XXIe siècle	Sécurité sanitaire, droits des usagers, inégalités, territoires, climat	Loi du 4 mars 2002 ; loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; loi HPST du 21 juillet 2009 (ARS) ; loi du 26 janvier 2016 ; SNS 2018-2022 (projet 2023-2033 non adopté en mai 2026)	PNNS (2001 à 2030), Nutri-Score, EGalim, SNANC

À retenir

La santé publique est passée de la **protection contre les épidémies** (isoler, assainir) à la **promotion de la santé** (agir sur les déterminants, renforcer le pouvoir d'agir). Les grandes lois françaises à citer sont : **1902** (première loi de santé publique), **2002** (droits des malades), **2004** (politique de santé publique), **2009** (ARS), **2016** (modernisation du système de santé, Nutri-Score).

À vous de jouer – Exercice d'application 1.1 ter – Situer une action dans l'histoire

Une diététicienne prépare l'exposé d'un projet « Bien boire, bien manger » dans une école. Le jury lui demande : « En quoi votre action est-elle l'héritière de l'histoire de la santé publique ? » Rédigez une réponse de 6 à 8 lignes qui cite au moins trois périodes et deux textes.

Corrigé – Exercice 1.1 ter (exemple de réponse)

« Mon action s'inscrit d'abord dans l'héritage **hygiéniste** du XIXe siècle : l'accès à une eau potable gratuite à l'école répond au souci d'assainir le milieu, déjà présent dans la loi de **1902**. Elle reprend ensuite l'approche du **XXe siècle** : avec la Charte d'**Ottawa** (1986), on ne se contente plus d'informer, on agit sur l'environnement (fontaines, menus) et on renforce les compétences des enfants. Enfin, elle relève du **XXIe siècle** : elle répond à une priorité du **PNNS 5** et du projet régional de santé de l'ARS, créée par la loi **HPST** (2009), et elle associe les parents, ce qui rejoint l'esprit de la démocratie sanitaire. » Le correcteur valorise : trois périodes nommées, deux textes datés, le lien avec l'action.

Les caractéristiques de l'approche de santé publique

Caractéristique	Approche clinique (BC1)	Approche de santé publique (BC3)
Cible	Un individu (le patient)	Une population ou un groupe (habitants d'un quartier, élèves, salariés, résidents)
Point de départ	Une demande de soin, une prescription médicale	Un diagnostic de situation : données épidémiologiques, besoins normatifs, exprimés, ressentis et observés
Objectif	Guérir, soulager, accompagner la personne	Maintenir et améliorer la santé du groupe, réduire les inégalités
Leviers	Bilan, diagnostic diététique, plan de soin, ETP	Environnements, politiques, communication, éducation, partenariats, plaidoyer
Acteurs	Équipe soignante	Équipe pluridisciplinaire et intersectorielle : santé, social, éducation, collectivités, associations, agriculture
Évaluation	Évolution clinique du patient	Indicateurs de processus et de résultats sur le groupe
Exemple en nutrition	Consultation diététique pour un enfant en situation d'obésité	Programme « goûters sains » dans toutes les écoles d'un quartier

Les missions de la santé publique

L'OMS et son bureau régional pour l'Europe ont décrit des **opérations essentielles de santé publique**, que l'on peut regrouper en grandes missions :

1. Observer et surveiller l'état de santé de la population et ses déterminants (données, indicateurs, enquêtes).

2. Veiller et alerter : détecter et répondre aux menaces sanitaires (épidémies, toxi-infections alimentaires collectives, contaminations).

3. Protéger : sécurité sanitaire des aliments, de l'eau, de l'environnement (réglementation, contrôles).

4. Promouvoir la santé : agir sur les déterminants, créer des environnements favorables, renforcer le pouvoir d'agir.

5. Prévenir les maladies et leurs complications (vaccination, dépistage, prévention nutritionnelle).

6. Éduquer et informer la population.

7. Organiser le système de santé et l'accès aux soins et à la prévention.

8. Former les professionnels, **chercher** et **évaluer** (recherche, données probantes, évaluation des politiques).

9. Gouverner : élaborer des politiques, les financer, coordonner les acteurs (gouvernance intersectorielle).

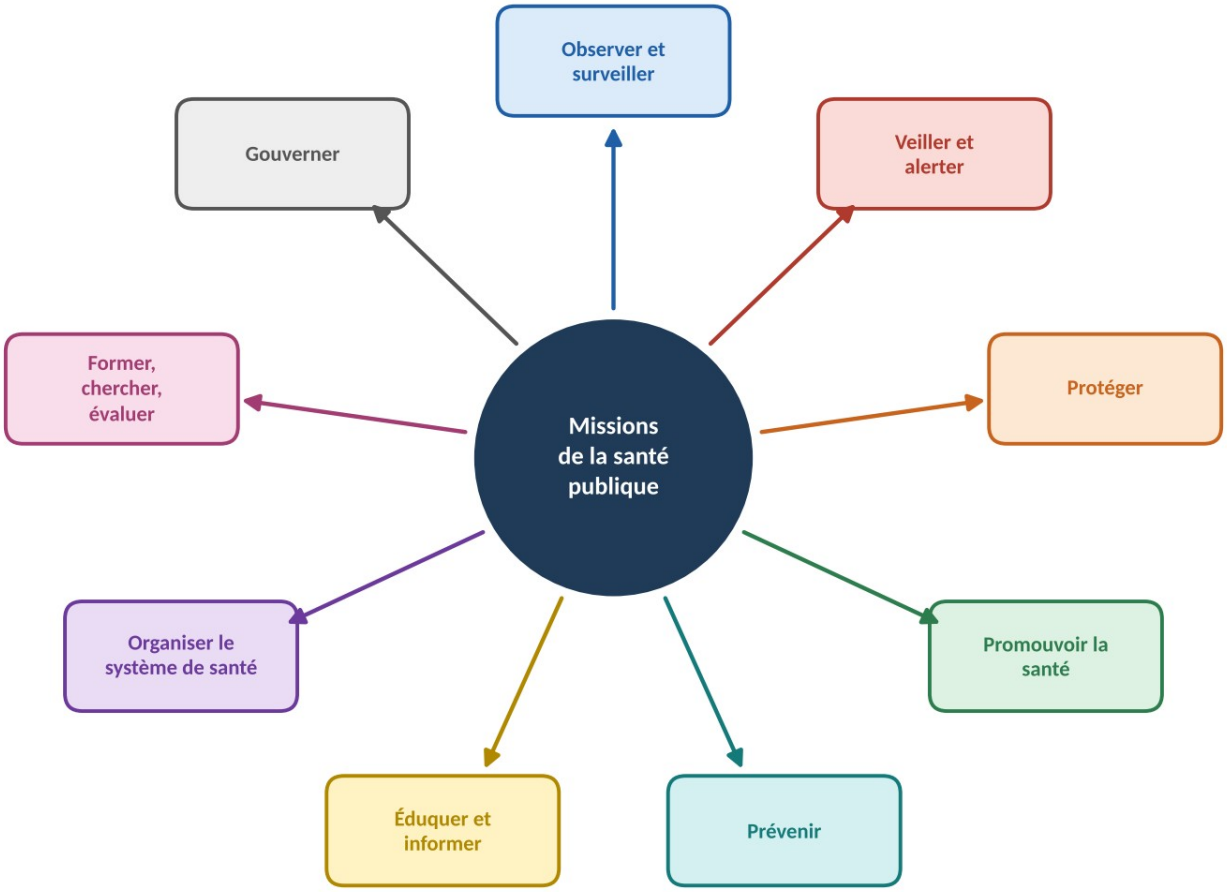


Figure 1.2 ter – Les neuf grandes missions de la santé publique

Comprendre le schéma – Figure 1.2 ter

1. Les neuf missions sont disposées en **cercle** : aucune n'est plus importante que les autres, elles s'enchaînent et se renforcent.
2. **Observer, veiller, protéger** : ce sont les missions de connaissance et de défense (données, alertes, sécurité sanitaire).
3. **Promouvoir, prévenir, éduquer** : ce sont les missions d'action auprès de la population ; c'est là que se situe surtout le diététicien.
4. **Organiser, former et évaluer, gouverner** : ce sont les missions qui donnent un cadre, des moyens et des règles.
5. Pour l'oral, retenez une phrase : « mon action relève surtout de la mission "promouvoir" ou "éduquer", et elle s'appuie sur les données de la mission "observer". »

Pourquoi agir sur toute la population ? Le paradoxe de la prévention

POUR MIEUX COMPRENDRE – niveau BTS (exigible) En 1985, l'épidémiologiste britannique **Geoffrey Rose** a montré qu'un **grand nombre de personnes exposées à un petit risque** peut générer **plus de cas** qu'un petit nombre de personnes exposées à un risque élevé. C'est le **paradoxe de la prévention** : une mesure qui apporte beaucoup à la population peut apporter peu à chaque individu qui y participe.

Exemple – Le paradoxe de Rose appliqué au sel

Imaginons une population de 100 000 adultes. 5 000 d'entre eux ont une hypertension sévère (risque élevé d'accident vasculaire cérébral) ; 95 000 ont une pression artérielle normale ou modérément élevée (risque

faible). Supposons, à titre pédagogique, que sur 10 ans, il survienne 10 AVC pour 1 000 personnes dans le groupe à haut risque et 2 pour 1 000 dans le groupe à faible risque. **Étape 1 – AVC dans le groupe à haut risque** : 5 000 × 10 / 1 000 = **50 AVC**. **Étape 2 – AVC dans le groupe à faible risque** : 95 000 × 2 / 1 000 = **190 AVC**. **Étape 3 – Total** : 50 + 190 = **240 AVC**, dont 190 / 240 = 0,79, soit **79 %** dans le groupe dit « à faible risque ». **Interprétation** : traiter uniquement les personnes à haut risque ne pourrait éviter, au mieux, que 21 % des AVC. Une mesure **populationnelle** (réduction du sel dans le pain, accord de filière, étiquetage) qui baisse légèrement la pression artérielle de tous agit sur la grande majorité des cas. C'est pourquoi les politiques nutritionnelles combinent stratégie **populationnelle** et stratégie **à haut risque** (dépistage et prise en charge).

À retenir

La santé publique s'intéresse à la **population** et pas seulement aux individus malades ; elle agit **collectivement** et **en amont**, sur les **déterminants** de la santé ; elle combine actions pour toute la population et actions ciblées (paradoxe de Rose).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 1.3.2 – La santé publique

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les auteurs et les dates des deux définitions de la santé publique étudiées.
2. Citez cinq missions de la santé publique.
3. Complétez : l'approche clinique vise …… ; l'approche de santé publique vise …… .
4. Expliquez le paradoxe de la prévention de Geoffrey Rose (1985) en trois lignes.
5. Citez trois lois françaises de santé publique avec leur date.
6. Calcul : 80 000 adultes dont 4 000 à haut risque (15 cas pour 1 000) et 76 000 à faible risque (3 cas pour 1 000). Quelle part des cas survient dans le groupe à faible risque ?

Corrigé – Point d'étape 1.3.2

1. Winslow (1920) ; OMS (1952), qui reprend et complète Winslow.
2. Observer et surveiller ; veiller et alerter ; protéger ; promouvoir la santé ; prévenir ; éduquer et informer ; organiser le système ; former, chercher, évaluer ; gouverner (cinq au choix).
3. Clinique : un individu (le patient), pour le soigner. Santé publique : une population, pour maintenir et améliorer sa santé et réduire les inégalités.
4. Beaucoup de personnes exposées à un petit risque produisent plus de cas que peu de personnes exposées à un risque élevé. Une mesure pour toute la population évite donc plus de cas, même si elle apporte peu à chaque individu.
5. Loi du 15 février 1902 (protection de la santé publique) ; loi du 4 mars 2002 (droits des malades) ; loi du 9 août 2004 (politique de santé publique) ; loi HPST du 21 juillet 2009 ; loi du 26 janvier 2016 (trois au choix).
6. Haut risque : 4 000 × 15 / 1 000 = 60 cas. Faible risque : 76 000 × 3 / 1 000 = 228 cas. Total : 288 cas. Part : 228 / 288 × 100 = 79,2 %.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

1.3.3 Problème de santé, danger, risque, facteur de risque et facteur de protection

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §4 (p. 5 et 6)

Pour définir des priorités, le diététicien doit nommer précisément ce qu'il cherche à éviter. Ces notions sont indispensables au diagnostic de situation (chapitre 7) et seront approfondies avec les déterminants (chapitre 2).

Notion	Définition	Exemple en nutrition
Problème de santé	Situation qui altère ou menace la santé d'une population, mesurable par des indicateurs (fréquence, gravité, coût, retentissement)	Obésité infantile, dénutrition des personnes âgées, carence en fer chez l'adolescente, insécurité alimentaire
Danger	Agent ou situation capable de provoquer un effet néfaste (propriété intrinsèque)	Listeria monocytogenes dans un fromage au lait cru ; excès de sel ; allergène (arachide)
Exposition	Contact entre la population et le danger (durée, fréquence, dose)	Consommation quotidienne de pain et de plats préparés riches en sel
Risque	Probabilité qu'un effet néfaste survienne, compte tenu du danger et de l'exposition : risque = danger × exposition	Probabilité de développer une hypertension dans une population qui consomme en moyenne 8 g de sel/jour
Facteur de risque	Caractéristique ou exposition associée à une probabilité accrue de maladie (sans être forcément la cause unique)	Sédentarité, consommation fréquente de boissons sucrées, tabagisme, faible revenu
Facteur de protection	Caractéristique associée à une probabilité réduite de maladie	Allaitement maternel, consommation de fruits, légumes et fibres, activité physique, soutien social
Population à risque	Groupe plus exposé ou plus vulnérable	Femmes enceintes (Listeria), personnes âgées isolées (dénutrition), enfants de familles précaires (obésité)

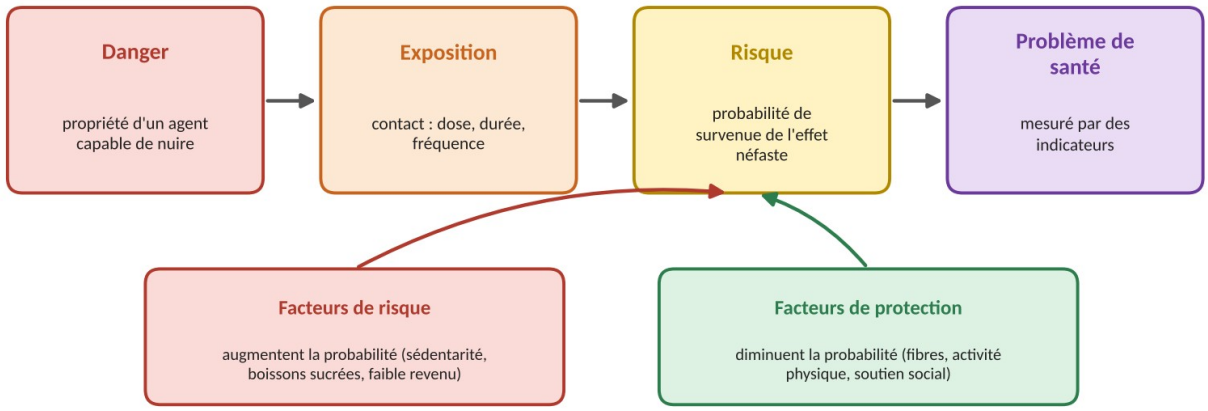


Figure 1.3 bis – Du danger au problème de santé : la chaîne du risque

Comprendre le schéma – Figure 1.3 bis

1. Le **danger** est une propriété de l'agent (le sel, une bactérie) : il existe même si personne n'y est exposé.
2. L'**exposition** décrit le contact avec le danger : dose, durée, fréquence.
3. Le **risque** naît de la rencontre du danger et de l'exposition : c'est une **probabilité**.
4. Quand le risque se réalise dans une population, il devient un **problème de santé**, que l'on mesure par des indicateurs (prévalence, incidence).
5. Sur les côtés, les **facteurs de risque** augmentent cette probabilité et les **facteurs de protection** la

diminuent : une action de santé publique cherche à réduire les premiers et à renforcer les seconds.

Attention – Facteur de risque n'est pas cause

Un facteur de risque est **associé statistiquement** à une maladie ; il n'en est pas forcément la cause directe. Par exemple, le fait de vivre dans un quartier prioritaire est associé à une plus forte prévalence d'obésité : ce n'est pas le quartier en lui-même qui « cause » l'obésité, mais un ensemble de déterminants (revenus, offre alimentaire, espaces pour l'activité physique, stress…). Les méthodes de l'épidémiologie (chapitre 16) permettent de discuter la causalité (critères de Bradford Hill).

À vous de jouer – Exercice d'application 1.2

Dans la situation suivante, identifiez le danger, l'exposition, le risque, deux facteurs de risque et un facteur de protection : « Dans un foyer d'hébergement, des résidents âgés de plus de 75 ans mangent seuls dans leur chambre ; certains ont des difficultés de mastication ; les repas sont livrés froids. On craint une dénutrition. »

Corrigé

- **Problème de santé visé** : la dénutrition des personnes âgées.
- **Danger** : des apports alimentaires insuffisants en énergie et en protéines (situation capable de provoquer une dénutrition).
- **Exposition** : repas pris seuls, en chambre, à chaque repas, de façon prolongée.
- **Risque** : probabilité qu'un résident devienne dénutri dans les mois à venir (plus élevée que dans une population qui mange en salle commune avec des textures adaptées).
- **Facteurs de risque** : âge > 75 ans, isolement social au moment du repas, troubles de la mastication, repas peu appétissants (froids).
- **Facteur de protection** : repas pris en commun (convivialité), textures adaptées, enrichissement des repas, surveillance du poids (lien BC1 : critères HAS/FFAMCO 2021 de la dénutrition de la personne de 70 ans et plus).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 1.3.3 – Danger, risque, facteurs de risque

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Définissez danger, exposition et risque.
2. Classez en facteur de risque ou facteur de protection : allaitement maternel ; sédentarité ; soutien social ; boissons sucrées quotidiennes.
3. Vrai ou faux : « Un facteur de risque est toujours la cause de la maladie. » Justifiez.
4. Donnez un exemple de population à risque pour la listériose et pour la dénutrition.
5. Dans la situation « des étudiants sautent le petit déjeuner et achètent des viennoiseries au distributeur », nommez le problème de santé visé et l'exposition.

Corrigé – Point d'étape 1.3.3

1. Danger : agent ou situation capable de provoquer un effet néfaste. Exposition : contact entre la population et le danger (durée, fréquence, dose). Risque : probabilité qu'un effet néfaste survienne, compte tenu du danger et de l'exposition.
2. Facteurs de protection : allaitement maternel, soutien social. Facteurs de risque : sédentarité, boissons sucrées quotidiennes.
3. Faux : un facteur de risque est associé statistiquement à la maladie ; il n'en est pas forcément la cause

directe (exemple du quartier prioritaire).

4. Listériose : femmes enceintes (et personnes âgées ou immunodéprimées). Dénutrition : personnes âgées isolées.
5. Problème de santé : déséquilibre alimentaire pouvant favoriser surpoids et baisse de concentration. Exposition : consommation répétée de produits gras et sucrés au distributeur, le matin, plusieurs fois par semaine.

Mon score	Ce que je fais
5 ou 4 sur 5	Je passe à la suite.
2 ou 3 sur 5	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 2 sur 5	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

1.3.4 Les modes d'intervention en santé publique

Module · Référentiel : C3.5 · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §4 (p. 5 et 6)

Le guide d'accompagnement (2025) distingue quatre modes d'intervention : la **surveillance et la veille sanitaire**, la **promotion de la santé**, la **prévention** et l'**éducation pour la santé** (nutritionnelle, alimentaire, sensorielle). Ils ne s'opposent pas : un projet bien construit les combine. Mais il faut savoir les **nommer précisément**, car le jury de l'épreuve E5 attend que vous qualifiiez correctement votre action.

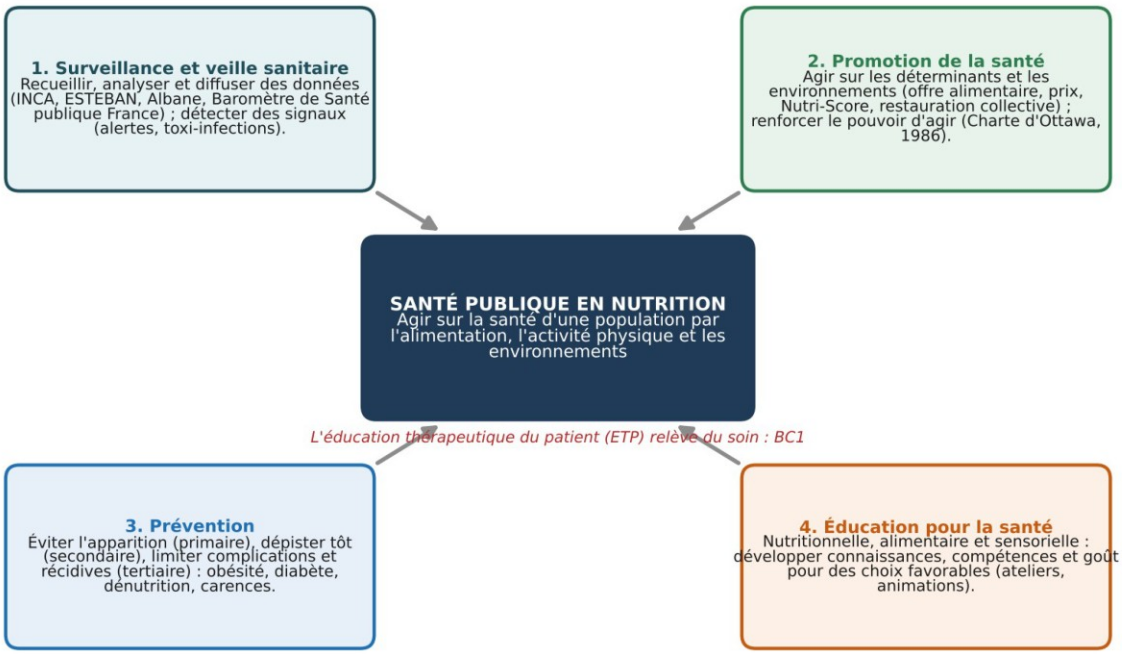


Figure 1.3 – Les quatre modes d'intervention en santé publique en nutrition

Comprendre le schéma – Figure 1.3

1. Au centre, la **santé publique en nutrition** : agir sur la santé d'une population par l'alimentation, l'activité physique et les environnements.
2. En haut à gauche, la **surveillance et la veille sanitaire** produisent les données qui permettent de connaître les problèmes et de suivre leur évolution.
3. En haut à droite, la **promotion de la santé** agit sur les déterminants et les environnements, et renforce le pouvoir d'agir.
4. En bas à gauche, la **prévention** cible un problème de santé précis, à différents moments de son histoire

naturelle.

5. En bas à droite, l'**éducation pour la santé** développe connaissances, compétences et goût chez les personnes.
6. La mention en rouge rappelle que l'**éducation thérapeutique du patient** relève du soin (BC1) et non de l'éducation pour la santé.

Mode 1 – La surveillance et la veille sanitaire

Définition – Surveillance épidémiologique

Collecte **systématique et continue** de données sur l'état de santé d'une population et ses déterminants, leur **analyse**, leur **interprétation** et leur **diffusion** aux personnes qui en ont besoin, afin d'orienter l'action (définition classique des Centers for Disease Control, reprise par Santé publique France).

Définition – Veille sanitaire

Ensemble des actions visant à **détecter le plus tôt possible** tout événement sanitaire anormal (« signal ») représentant un risque pour la santé de la population, à l'**évaluer** et à **alerter** les autorités pour qu'elles agissent. En France, la veille sanitaire est confiée à **Santé publique France** (créée le 1er mai 2016 par regroupement de l'InVS, de l'INPES, de l'EPRUS et d'Adalis).

En nutrition, la **surveillance** repose sur des enquêtes répétées : études **INCA** (ANSES ; INCA 3 réalisée en 2014-2015, publiée en 2017), **ESTEBAN** (Santé publique France, 2014-2016), cohorte **NutriNet-Santé** (depuis 2009), **Baromètre de Santé publique France**, enquêtes de santé scolaire de la Drees (grande section, CM2, 3e), et désormais l'enquête **Albane**, lancée en juin 2025 par Santé publique France et l'ANSES, qui associera tous les deux ans questionnaires, carnets alimentaires de trois jours, accéléromètres et examens de santé avec prélèvements biologiques (premiers résultats attendus début 2028). La **veille sanitaire** concerne surtout la sécurité des aliments : déclaration obligatoire des **toxi-infections alimentaires collectives (TIAC)** auprès de l'ARS, alertes et rappels de produits (site **RappelConso**, depuis avril 2021), nutrivigilance de l'ANSES (effets indésirables des compléments alimentaires).

Lien diététique – Le diététicien et la surveillance

Le diététicien est **utilisateur** des données de surveillance (pour poser un diagnostic, chapitre 2) et parfois **producteur** : enquêteur dans une étude nationale, participation aux enquêtes de consommation en restauration collective, signalement d'une TIAC dans un établissement, déclaration d'un effet indésirable en nutrivigilance.

Mode 2 – La promotion de la santé

Définition – Promotion de la santé – Charte d'Ottawa (OMS, 21 novembre 1986)

« La promotion de la santé est le **processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer celle-ci**. Cette démarche relève d'un concept définissant la santé comme la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut, d'une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d'autre part, évoluer avec le milieu ou s'adapter à celui-ci. » Charte adoptée lors de la première Conférence internationale pour la promotion de la santé, Ottawa (Canada), 17-21 novembre 1986.

La promotion de la santé ne vise pas une maladie particulière : elle vise à **améliorer la santé et le bien-être** en agissant sur l'ensemble des **déterminants** (revenus, logement, éducation, offre alimentaire, environnement…) et

en renforçant la **capacité des personnes et des communautés à agir** (*empowerment*, ou pouvoir d'agir). Elle est **positive** (on cherche à développer des ressources) et **politique** (on agit sur les politiques publiques, pas seulement sur les comportements).

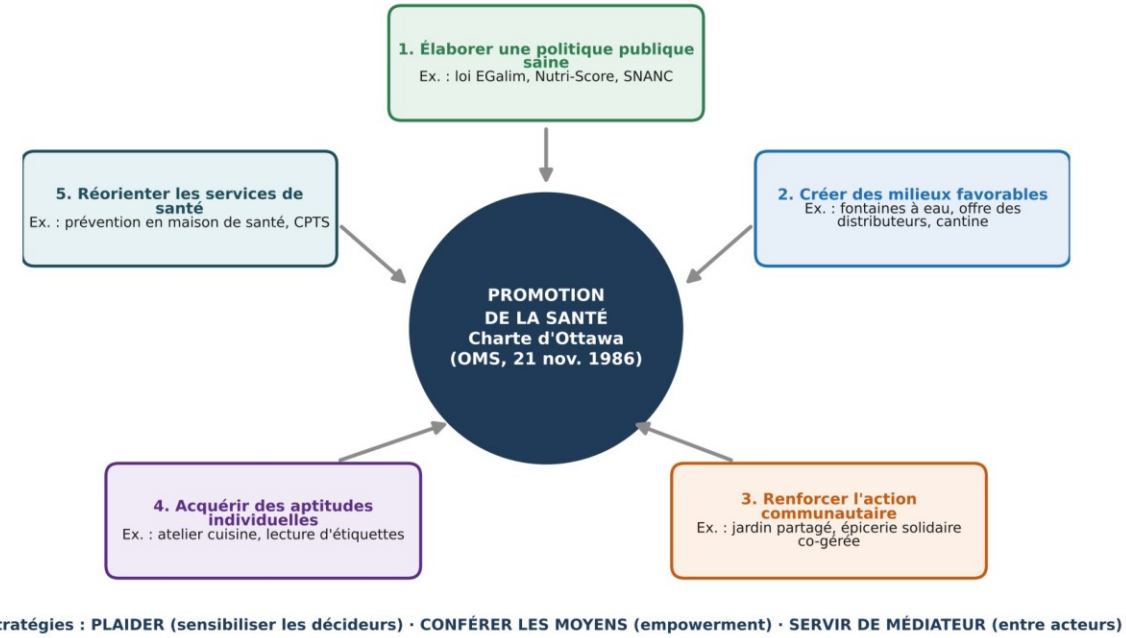


Figure 1.4 – Les cinq domaines d'action et les trois stratégies de la Charte d'Ottawa, illustrés en nutrition

Comprendre le schéma – Figure 1.4

1. Élaborer une politique publique saine : la santé doit être inscrite à l'ordre du jour de tous les décideurs, dans tous les secteurs (agriculture, éducation, urbanisme, économie). Exemples : loi EGalim, Nutri-Score, SNANC.

2. Créer des milieux favorables : rendre les choix sains plus faciles dans les lieux de vie (école, travail, quartier). Exemples : fontaines à eau, suppression des distributeurs de boissons sucrées dans les écoles (loi du 9 août 2004), offre de fruits.

3. Renforcer l'action communautaire : les habitants participent à la définition des priorités et à l'action. Exemples : jardin partagé, épicerie solidaire co-gérée, groupe de parents.

4. Acquérir des aptitudes individuelles : informer, éduquer, développer les compétences. Exemples : atelier cuisine, lecture d'étiquettes, éducation au goût.

5. Réorienter les services de santé : passer d'un système centré sur le soin à un système qui intègre la prévention. Exemples : prévention en maison de santé pluriprofessionnelle, CPTS, rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie.

6. Le bandeau du bas rappelle les **trois stratégies** : **plaider** (convaincre les décideurs), **conférer les moyens** (donner aux personnes les moyens d'agir) et **servir de médiateur** (concilier les intérêts des différents acteurs).

À retenir – Charte d'Ottawa : 5 + 3

5 domaines d'action : politique publique saine ; milieux favorables ; action communautaire ; aptitudes individuelles ; réorientation des services de santé. **3 stratégies** : plaider, conférer les moyens (habiliter), servir de médiateur. Moyen mnémotechnique : « **P**our **M**anger **C**orrectement, **A**gissons **R**apidement » (Politique, Milieux, Communautaire, Aptitudes, Réorienter).

POUR MIEUX COMPRENDRE – niveau BTS (exigible)

Les conférences et chartes qui ont suivi Ottawa

Année et lieu	Apport principal
1978 – Alma-Ata	Déclaration sur les soins de santé primaires : « la santé pour tous en l'an 2000 » ; participation de la population ; la santé dépend du développement économique et social
1986 – Ottawa	Charte de la promotion de la santé (5 domaines, 3 stratégies)
1988 – Adélaïde	Politiques publiques favorables à la santé ; l'alimentation et la nutrition sont un domaine prioritaire
1997 – Jakarta	Partenariats, implication du secteur privé, investissement dans la santé
2005 – Bangkok	Charte de Bangkok : promotion de la santé à l'heure de la mondialisation ; engagement des entreprises
2010 – Adélaïde	Santé dans toutes les politiques (Health in All Policies), réaffirmée à Helsinki en 2013
2016 – Shanghai	Déclaration de Shanghai : promotion de la santé et Objectifs de développement durable (2030), villes-santé, littératie en santé
2021 – Genève	Charte de Genève pour le bien-être : sociétés du bien-être, santé de la planète

Les principes d'action de la promotion de la santé

- **Agir sur les déterminants** plutôt que sur les seuls comportements (chapitre 2). Le modèle des déterminants de Dahlgren et Whitehead (1991) est l'outil de référence pour les visualiser.
- **Participation** des personnes concernées à toutes les étapes du projet (du diagnostic à l'évaluation) : on fait **avec** les personnes, pas **pour** elles.
- **Renforcement du pouvoir d'agir** (*empowerment*) individuel et collectif.
- **Intersectorialité** : santé, social, éducation, urbanisme, agriculture, économie.
- **Réduction des inégalités sociales de santé** : selon le principe de l'**universalisme proportionné**.
- **Approche par milieux de vie** (*settings*) : écoles promotrices de santé, entreprises, villes-santé de l'OMS (réseau français des Villes-Santé, créé en 1990).
- **Non-stigmatisation** : on ne culpabilise pas les personnes (par exemple, on parle de « personnes vivant avec une obésité » et on évite les messages qui opposent « bons » et « mauvais » aliments de façon moralisatrice).

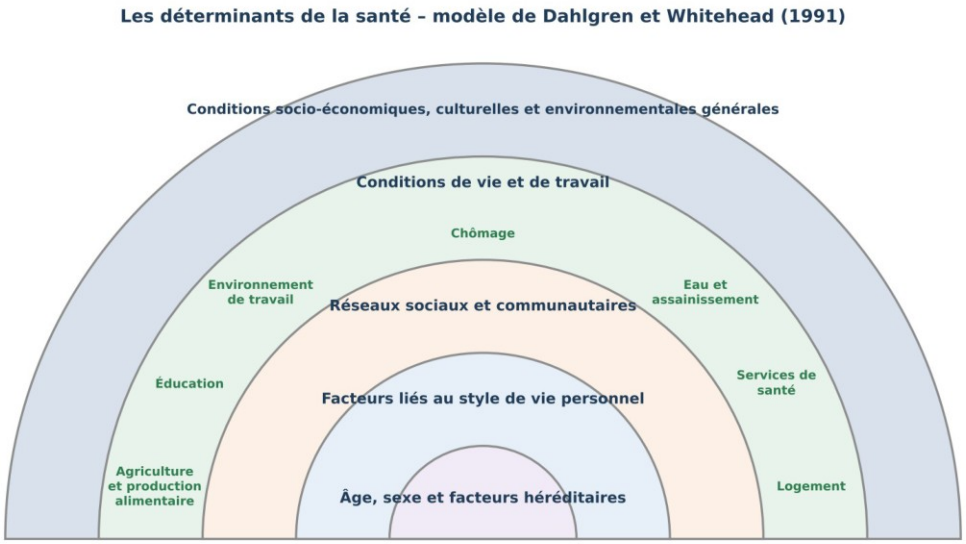


Figure 1.5 – Les déterminants de la santé selon Dahlgren et Whitehead (1991)

Comprendre le schéma – Figure 1.5

1. Au centre, les **facteurs individuels non modifiables** : âge, sexe, facteurs héréditaires.

2. Deuxième couche : les **facteurs liés au style de vie personnel** (alimentation, activité physique, tabac, alcool, sommeil). C'est là que se situent les « comportements », mais ils sont influencés par toutes les couches extérieures.
3. Troisième couche : les **réseaux sociaux et communautaires** (famille, amis, voisinage, soutien social).
4. Quatrième couche : les **conditions de vie et de travail** : agriculture et production alimentaire, éducation, environnement de travail, chômage, eau et assainissement, services de santé, logement.
5. Couche extérieure : les **conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales** (politiques économiques, fiscales, culture, climat).
6. Lecture : plus on agit sur les couches **extérieures**, plus l'action touche de personnes et réduit les inégalités ; agir seulement au centre (« manger mieux ») sans agir sur les couches externes (prix, offre, revenus) a un effet limité et peut accroître les inégalités. Ce modèle sera détaillé au chapitre 2.

Définition – Universalisme proportionné (Michael Marmot, *Fair Society, Healthy Lives*, 2010)

Principe selon lequel les actions doivent être **universelles** (destinées à toute la population), mais avec une **intensité proportionnelle au niveau de désavantage** social. Il évite deux écueils : l'action universelle seule, qui profite surtout aux plus favorisés (qui ont plus de ressources pour s'en saisir), et l'action ciblée seule, qui stigmatise et oublie le **gradient social** (la santé se dégrade progressivement à chaque échelon de l'échelle sociale, pas seulement chez les plus pauvres).

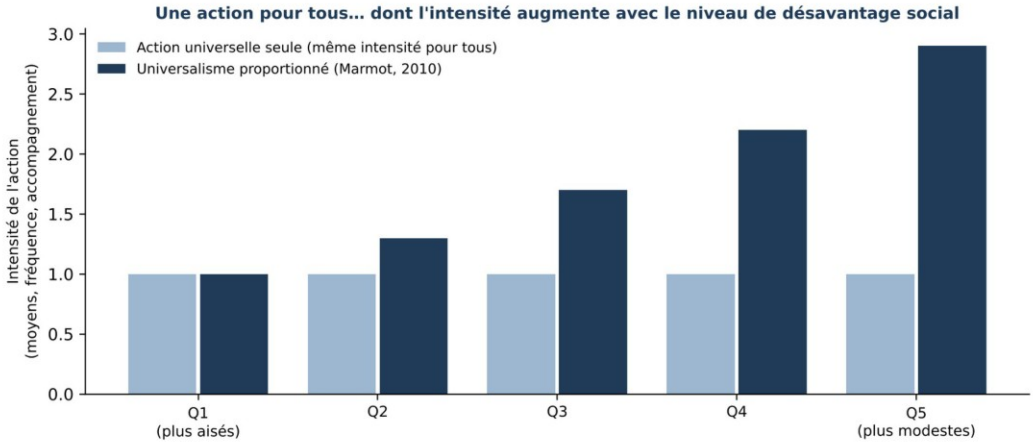


Figure 1.6 – L'universalisme proportionné : une action pour tous, plus intense pour les plus défavorisés

Comprendre le schéma – Figure 1.6

1. L'axe horizontal classe la population en cinq groupes (quintiles) du plus aisé (Q1) au plus modeste (Q5).
2. Les barres claires représentent une **action universelle seule** : la même intensité pour tous.
3. Les barres foncées représentent l'**universalisme proportionné** : l'action existe pour tous, mais son intensité (moyens, fréquence, accompagnement) augmente avec le désavantage.
4. Exemple : une cantine scolaire ouverte à tous (universel), avec une **tarification sociale** (les familles les plus modestes paient moins, dispositif de la « cantine à 1 euro » soutenu par l'État pour les communes rurales éligibles depuis 2019) et un accompagnement renforcé dans les écoles des quartiers prioritaires.

Mode 3 – La prévention

Définition – Prévention – OMS (1948)

« Ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. » La prévention part toujours d'un **problème de santé défini** que l'on cherche à éviter ou à limiter.

La classification de l'OMS selon le moment de l'intervention

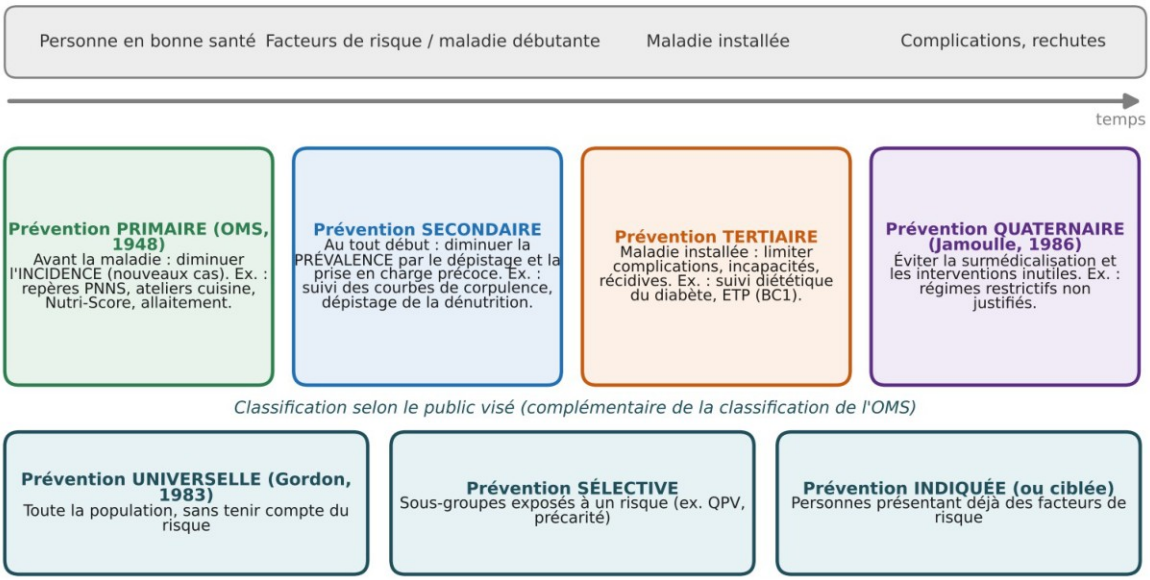


Figure 1.7 – Les niveaux de prévention selon l'OMS et selon Gordon

Comprendre le schéma – Figure 1.7

1. La bande grise représente l'**histoire naturelle de la maladie** dans le temps : bonne santé → facteurs de risque ou maladie débutante → maladie installée → complications.

2. **Prévention primaire** (vert) : intervient **avant** l'apparition de la maladie ; elle vise à diminuer l'**incidence** (le nombre de nouveaux cas). En nutrition : repères du PNNS, éducation alimentaire, promotion de l'allaitement, ateliers cuisine, Nutri-Score, réduction du sel dans le pain.

3. **Prévention secondaire** (bleu) : intervient **au tout début** de la maladie, souvent avant les symptômes ; elle vise à diminuer la **prévalence** (le nombre de cas existants) en réduisant la durée de la maladie par un dépistage et une prise en charge précoces. En nutrition : suivi des courbes de corpulence par le médecin ou la PMI (repérage du rebond d'adiposité précoce), dépistage de la dénutrition à l'entrée en EHPAD, dépistage du diabète de type 2.

4. **Prévention tertiaire** (orange) : intervient quand la maladie est **installée** ; elle vise à réduire les **complications, les incapacités et les récidives**. En nutrition : prise en charge diététique du diabète, de l'insuffisance rénale, réhabilitation nutritionnelle ; l'ETP en fait partie (BC1).

5. **Prévention quaternaire** (violet) : notion proposée par Marc Jamoulle (1986) ; elle vise à protéger les personnes de la **surmédicalisation** et des interventions inutiles ou nocives. En nutrition : éviter les régimes restrictifs non justifiés, les compléments alimentaires inutiles, les exclusions alimentaires sans diagnostic.

6. En bas, la **classification de Gordon (1983)**, fondée sur le **public visé** : universelle (toute la population), sélective (sous-groupes exposés à un risque), indiquée (personnes présentant déjà des facteurs de risque).

La classification de Gordon selon la population visée

Type	Public visé	Exemple en nutrition
Universelle	Toute la population, sans distinction de risque	Campagne « Manger Bouger », repères PNNS, Nutri- Score, menu végétarien hebdomadaire à l'école
Sélective	Sous-groupes exposés à un risque particulier, sans signe de maladie	Ateliers cuisine petit budget pour les familles d'un quartier prioritaire ; prévention de la carence en fer chez les adolescentes ; actions « 1000 premiers jours » auprès des femmes enceintes en situation de précarité
Indiquée (ou ciblée)	Personnes présentant déjà des facteurs de risque ou des signes précoces	Programme d'activité physique et d'alimentation pour les enfants en surpoids repérés par la santé scolaire (par exemple dispositif « Mission : retrouve ton cap », prise en charge pluridisciplinaire du surpoids de l'enfant financée par l'Assurance maladie)

Une troisième classification : la prévention globale (Robert San Marco, 2003)

Robert San Marco distingue la prévention **« de maladies »** (centrée sur un risque, souvent descendante) et la prévention **« globale »** ou **positive**, centrée sur la **personne** et sa qualité de vie, qui rejoint la promotion de la santé. Cette distinction est utile pour critiquer les campagnes uniquement fondées sur la peur.

Attention – Les erreurs classiques sur la prévention

- Confondre **incidence** (nouveaux cas, que la prévention primaire fait baisser) et **prévalence** (cas existants, que la prévention secondaire fait baisser en raccourcissant la durée de la maladie).
- Classer un **dépistage** en prévention primaire : le dépistage repère une maladie ou un facteur de risque **déjà présent** ; il relève de la prévention secondaire.
- Classer l'**ETP** en éducation pour la santé : l'ETP s'adresse à des **patients** ayant une maladie chronique ; elle relève du soin et de la prévention tertiaire (BC1).
- Croire qu'une action « universelle » est forcément équitable : sans universalisme proportionné, elle peut **creuser les inégalités**.

Mode 4 – L'éducation pour la santé

Définition – Éducation pour la santé (définition reprise par l'INPES puis Santé publique France)

L'éducation pour la santé « a pour but que chaque citoyen acquière, tout au long de sa vie, les **compétences** et les **moyens** lui permettant de promouvoir sa santé et sa qualité de vie ainsi que celles de la collectivité » (Plan national d'éducation pour la santé, 2001). Elle comprend toute combinaison d'expériences d'apprentissage visant à faciliter l'adoption **volontaire** de comportements favorables à la santé.

L'éducation pour la santé est **une composante** de la promotion de la santé (domaine « acquérir des aptitudes individuelles ») et un **moyen** de la prévention. Elle respecte la **liberté** des personnes : elle ne cherche pas à imposer un comportement, mais à donner les moyens de faire des choix éclairés. Le guide du BTS (2025) distingue trois formes en nutrition.

Forme	Contenu	Exemples d'actions
Éducation nutritionnelle	Connaissances sur les nutriments, les besoins, les repères, les liens alimentation-santé	Atelier « lire une étiquette et comprendre le Nutri-Score » ; jeu des familles d'aliments ; quiz sur les repères PNNS

Forme	Contenu	Exemples d'actions
Éducation alimentaire	Pratiques concrètes : choisir, acheter, conserver, cuisiner, organiser ses repas, gérer un budget, limiter le gaspillage ; dimensions culturelles et sociales	Atelier culinaire « repas complet à moins de 2 € » ; visite d'un marché ; atelier « batch cooking » ; atelier anti-gaspillage
Éducation sensorielle (éducation au goût)	Découverte des cinq sens, du vocabulaire sensoriel, du plaisir de manger ; lutte contre la néophobie	Classes du goût (méthode de Jacques Puisais, 1975, Institut du goût) ; ateliers d'éveil sensoriel en maternelle ; dégustations à l'aveugle ; « Semaine du goût » (depuis 1990, en octobre)

Les approches éducatives : de l'information à la participation

Approche	Principe	Limite	Exemple
Informative	Transmettre des connaissances (« savoir pour bien faire »)	Savoir ne suffit pas à changer : beaucoup de personnes savent qu'il faut manger 5 fruits et légumes	Affiche, dépliant, conférence
Persuasive (ou comportementale)	Convaincre de changer un comportement, parfois par la peur	Culpabilise, peut renforcer les inégalités et la stigmatisation	Campagne choc, injonction
Participative (ou humaniste, d'empowerment)	Partir des représentations et des besoins des personnes ; développer leurs compétences et leur pouvoir d'agir	Plus longue, demande des compétences d'animation	Atelier où les parents choisissent les recettes ; photolangage ; débat ; co-construction d'un livret

À retenir

En santé publique, on privilégie l'**approche participative** et le développement des **compétences psychosociales (CPS)** : Santé publique France a publié en 2022 un **référentiel des CPS** (compétences cognitives, émotionnelles et sociales) et une stratégie nationale de développement des CPS des enfants et des jeunes (2022-2037) ; ces compétences sont un déterminant majeur de la santé et du bien-être (chapitre 3).

Deux autres modes souvent cités : la sécurité sanitaire et la restauration de la santé

Les cours du CNED et de nombreux manuels présentent **cinq ou six** modes d'intervention, alors que le guide 2025 en retient quatre. Il n'y a pas de contradiction : les deux modes supplémentaires sont, soit inclus dans un mode du guide, soit hors du champ du BC3. Il faut savoir les reconnaître si un document ou un membre du jury les cite.

Définition – Sécurité sanitaire

Ensemble des mesures qui **protègent la population contre les risques** liés aux produits de santé, aux aliments, à l'eau, à l'environnement et aux soins. Elle associe la **veille** (détecter), l'**expertise** (évaluer le risque), la **gestion** (décider et agir : retrait, rappel, interdiction) et la **communication**. Elle repose sur le **principe de précaution** (article 5 de la Charte de l'environnement, 2005).

Définition – Restauration de la santé

Actions qui visent à **rétablir la santé** quand la maladie est installée : soins curatifs, réadaptation, réinsertion. Elle correspond à la prévention **tertiaire** de l'OMS et à l'**éducation thérapeutique du patient** ; elle relève surtout du soin (BC1 et BC2).

Mode cité par le CNED ou un manuel	Où le placer avec les quatre modes du guide 2025	Exemple en nutrition
Veille et sécurité sanitaire	Mode 1 (surveillance et veille) pour la détection ; mission « protéger » de la santé publique pour la gestion	Rappel d'un lot de préparation infantile contaminée ; enquête sur une TIAC dans une cantine
Restauration de la santé	Hors BC3 : soin (BC1) ; prévention tertiaire	Prise en charge diététique d'un patient après un infarctus ; programme d'ETP diabète
Promotion de la santé	Mode 2	Projet alimentaire territorial, fontaines à eau dans un quartier
Prévention	Mode 3	Dépistage de la dénutrition en EHPAD
Éducation pour la santé	Mode 4	Ateliers culinaires, éducation sensorielle

Exemple – La sécurité sanitaire des aliments : une chaîne d'acteurs

1. Le signal : trois enfants d'une même école ont des diarrhées et des vomissements le même soir. Le médecin déclare une **TIAC** (au moins deux cas groupés, symptômes similaires, même origine alimentaire) à l'**ARS**.

2. L'enquête : l'ARS et la direction départementale chargée de la protection des populations (DDPP ou DDETSPP) enquêtent sur le repas suspect ; Santé publique France analyse les données ; le laboratoire analyse les plats témoins.

3. L'évaluation : l'**ANSES** (créée en 2010) apporte l'expertise scientifique sur le danger.

4. La gestion : la préfecture ou le ministère décide du retrait ou du rappel des produits ; le rappel est publié sur **RappelConso**.

5. Le rôle du diététicien de la cuisine centrale : fournir les plats témoins conservés 5 jours, les fiches de traçabilité et le plan de maîtrise sanitaire (chapitre 13).

À retenir

Retenez les **quatre modes du guide 2025** pour qualifier votre action à l'épreuve E5. Sachez aussi que la **sécurité sanitaire** protège la population contre les risques (aliments, eau, produits) et que la **restauration de la santé** relève du soin. Ces deux notions existent, mais elles ne remplacent pas les quatre modes.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.2 bis – Classer des actions

Classez chaque action dans l'un des quatre modes du guide 2025, ou indiquez qu'elle relève de la sécurité sanitaire ou de la restauration de la santé.

a) L'ANSES publie un avis sur les risques liés aux boissons énergisantes.

b) Une diététicienne anime six séances d'ETP pour des patients insuffisants rénaux.

c) Une commune installe des fontaines à eau dans tous ses parcs.

d) Un lot de fromage contaminé par *Listeria* est rappelé sur RappelConso.

e) Santé publique France publie les résultats de l'étude Esteban sur la corpulence.

f) Un atelier « goûter maison » est proposé aux parents d'une crèche.

Corrigé – Exercice 1.2 bis

a) **Sécurité sanitaire** (évaluation du risque par une expertise) ; elle prépare une décision de gestion.

b) **Restauration de la santé** : ETP, prévention tertiaire, champ du soin (BC1).

c) **Promotion de la santé** : on rend l'environnement favorable (choix facile de l'eau).

d) **Sécurité sanitaire** (gestion du risque : retrait et rappel).

e) **Surveillance** (mode 1) : données répétées sur l'état de santé de la population.

f) **Éducation pour la santé** (mode 4) : développer des compétences des parents.

Distinguer promotion de la santé, prévention, éducation pour la santé et ETP

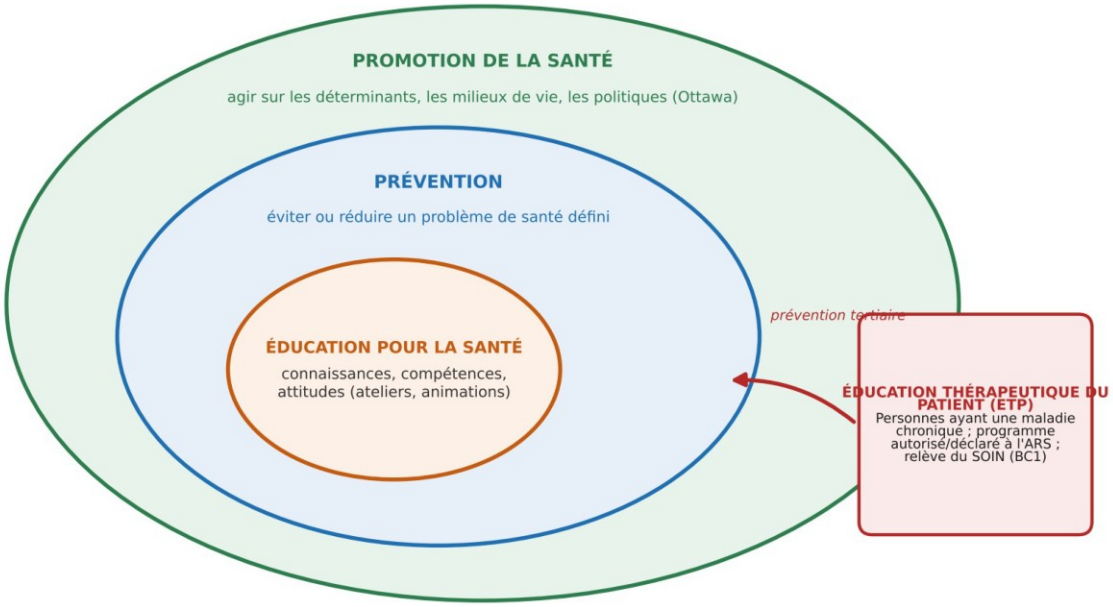


Figure 1.8 – Emboîtement des notions : promotion, prévention, éducation pour la santé et éducation thérapeutique du patient

Comprendre le schéma – Figure 1.8

1. La grande ellipse verte, la **promotion de la santé**, est la notion la plus large : elle agit sur tous les déterminants et sur les politiques.
2. L'ellipse bleue, la **prévention**, est incluse dans la promotion : elle vise des problèmes de santé définis.
3. L'ellipse orange, l'**éducation pour la santé**, est l'un des moyens de la prévention et de la promotion : elle développe les compétences des personnes.
4. Le cadre rouge, l'**ETP**, se situe à part, du côté du **soin** : elle s'adresse à des patients ayant une maladie chronique, dans un programme déclaré à l'ARS ; la flèche rappelle qu'elle participe à la **prévention tertiaire**.

Critère	Promotion de la santé	Prévention	Éducation pour la santé	ETP (BC1)
Cible	Population, milieux de vie, décideurs	Population ou groupe exposé à un problème	Personnes, groupes (bien portants)	Patient atteint d'une maladie chronique et son entourage
Objectif	Améliorer la santé et le bien-être, réduire les inégalités, renforcer le pouvoir d'agir	Éviter ou réduire un problème de santé défini	Développer connaissances, compétences, attitudes	Acquérir des compétences d'autosoins et d'adaptation pour gérer sa maladie
Point de départ	Déterminants de santé	Maladie ou facteur de risque	Besoins éducatifs du public	Diagnostic éducatif (bilan éducatif partagé)

Critère	Promotion de la santé	Prévention	Éducation pour la santé	ETP (BC1)
Leviers	Politiques, environnements, action communautaire, éducation, services	Information, dépistage, vaccination, éducation, réglementation	Ateliers, animations, outils pédagogiques	Programme structuré (séances individuelles et collectives)
Cadre	Charte d'Ottawa ; SNS ; PRS	OMS 1948 ; Gordon 1983	PNES 2001 ; Santé publique France	Loi HPST du 21 juillet 2009 (art. L. 1161-1 CSP) ; HAS 2007 ; programmes déclarés à l'ARS (depuis 2021)
Exemple	Charte « Ville active PNNS », plan alimentaire territorial	Dépistage de la dénutrition à l'entrée en EHPAD	Atelier cuisine parents-enfants	Séance « adapter son alimentation à son diabète » pour des patients d'un service hospitalier

Exemple – Un même thème, quatre modes d'intervention : la consommation de boissons sucrées chez les enfants

- **Surveillance** : les enquêtes de santé scolaire et ESTEBAN mesurent la consommation et la corpulence des enfants ; les données montrent un gradient social.
- **Promotion de la santé** : taxe sur les boissons sucrées (en France depuis 2012, rendue progressive en fonction de la teneur en sucres en 2018 et renforcée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025) ; installation de fontaines à eau dans les écoles ; interdiction des distributeurs automatiques payants dans les établissements scolaires (loi du 9 août 2004).
- **Prévention** (primaire, sélective) : programme dans les écoles d'un quartier où la prévalence du surpoids est élevée.
- **Éducation pour la santé** : atelier « fabriquer des eaux aromatisées et des goûters maison » avec les parents et les enfants ; jeu sur la quantité de sucre dans les boissons.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.3 – Qualifier une action

Pour chaque action, indiquez le ou les mode(s) d'intervention, le niveau de prévention (OMS) et le type (Gordon) : **a)** Une mairie signe la charte « Ville active du PNNS » et rénove l'offre de sa cantine. **b)** Une infirmière scolaire mesure poids et taille des élèves de grande section et oriente les enfants dont la courbe de corpulence monte. **c)** Une diététicienne anime 6 ateliers cuisine petit budget pour les familles d'une épicerie solidaire. **d)** Un service de diabétologie organise des séances collectives sur le comptage des glucides pour des patients diabétiques de type 1. **e)** Santé publique France diffuse un spot télévisé sur les repères « Manger Bouger ».

Corrigé

a) Promotion de la santé (politique publique locale saine, milieu favorable) ; prévention **primaire**, **universelle** (tous les enfants de la commune). **b) Prévention secondaire** (repérage précoce du surpoids, avant les complications) ; **indiquée** pour les enfants orientés (ils présentent déjà un signe : la courbe qui monte) ; c'est aussi de la **surveillance** si les données sont agrégées. **c) Éducation pour la santé** (alimentaire et nutritionnelle) au service de la **prévention primaire**, **sélective** (public exposé à un risque du fait de la précarité) ; elle relève aussi de la **promotion de la santé** si les familles participent au choix des thèmes (renforcement du pouvoir d'agir) et si le projet agit sur l'offre (partenariat avec l'épicerie). **d) Éducation thérapeutique du patient** (BC1), **prévention tertiaire** : il ne s'agit pas d'éducation pour la santé, car les participants sont des patients atteints d'une maladie chronique, dans un programme de soin. **e) Éducation pour la santé** de type **informative** (communication de masse), **prévention primaire universelle**.

POUR MIEUX COMPRENDRE – niveau BTS (exigible)

Le marketing social et les « nudges »

Le **marketing social** applique les techniques du marketing commercial (connaissance du public, segmentation, produit, prix, distribution, communication : les « 4 P ») pour favoriser un comportement favorable à la santé (par exemple, le programme anglais *Change4Life*). Les **nudges** (« coups de pouce », Thaler et Sunstein, 2008) modifient l'**architecture du choix** sans interdire ni culpabiliser : placer les fruits à hauteur des yeux et en début de chaîne au self, proposer l'eau par défaut au menu enfant, servir des portions adaptées. Ils sont efficaces pour des comportements quotidiens, mais ne remplacent pas l'action sur les déterminants structurels (prix, revenus, offre).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 1.3.4 – Les modes d'intervention

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre modes d'intervention du guide 2025.
2. Citez les cinq domaines d'action et les trois stratégies de la Charte d'Ottawa.
3. Classez selon l'OMS (primaire, secondaire, tertiaire) : dépistage de la dénutrition en EHPAD ; atelier cuisine pour des familles sans maladie ; ETP d'un patient diabétique.
4. Classez selon Gordon (universelle, sélective, indiquée) : un message pour tous les élèves d'un collège ; un atelier pour les familles d'un quartier prioritaire ; un suivi pour des enfants déjà en surpoids.
5. Quelle différence faites-vous entre la sécurité sanitaire et la restauration de la santé ?
6. Citez les trois formes d'éducation pour la santé en nutrition et donnez un exemple pour chacune.

Corrigé – Point d'étape 1.3.4

1. Surveillance et veille sanitaire ; promotion de la santé ; prévention ; éducation pour la santé.
2. Domaines : élaborer une politique publique saine ; créer des milieux favorables ; renforcer l'action communautaire ; acquérir des aptitudes individuelles ; réorienter les services de santé. Stratégies : promouvoir (plaider), conférer les moyens, servir de médiateur.
3. Dépistage : secondaire. Atelier cuisine : primaire. ETP : tertiaire.
4. Tous les élèves : universelle. Quartier prioritaire : sélective. Enfants déjà en surpoids : indiquée.
5. La sécurité sanitaire protège la population contre les risques (aliments, eau, produits) : veille, expertise, gestion, communication. La restauration de la santé rétablit la santé d'une personne malade (soins, réadaptation, ETP) : elle relève du soin.
6. Nutritionnelle (lire une étiquette, comprendre le Nutri-Score) ; alimentaire (atelier culinaire petit budget) ; sensorielle (classes du goût, dégustation à l'aveugle).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

1.3.5 Les acteurs et les organismes de la santé publique en nutrition

Module · Référentiel : C3.4, activité 3.1 · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S2 §1.1 (p. 8) ; Essentiels M1 S3 §1.1 et §1.2 (p. 13 et 14) ; Essentiels M1 S3 §1.3 et §1.4 (p. 14 et 15) ; Essentiels M1 S3 §1.5 (p. 15) ; Essentiels M1 S3 §1.6 (p. 15 et 16)

La santé publique en nutrition est **intersectorielle** : elle mobilise la santé, mais aussi l'agriculture, l'éducation, l'économie, l'environnement, la cohésion sociale. Connaître les acteurs est indispensable pour trouver des **données** (diagnostic), des **financements** (appels à projets), des **partenaires** (parties prenantes) et des **ressources** (outils pédagogiques validés).

Une typologie des acteurs selon leur rôle

Avant de présenter les acteurs par niveau (international, européen, national, régional, local), il est utile de les classer selon leur **rôle** dans une politique de santé. Le CNED retient **quatre types d'acteurs**. Un même organisme peut jouer plusieurs rôles : l'ARS décide (elle arrête le PRS), finance (fonds d'intervention régional) et pilote la mise en œuvre.

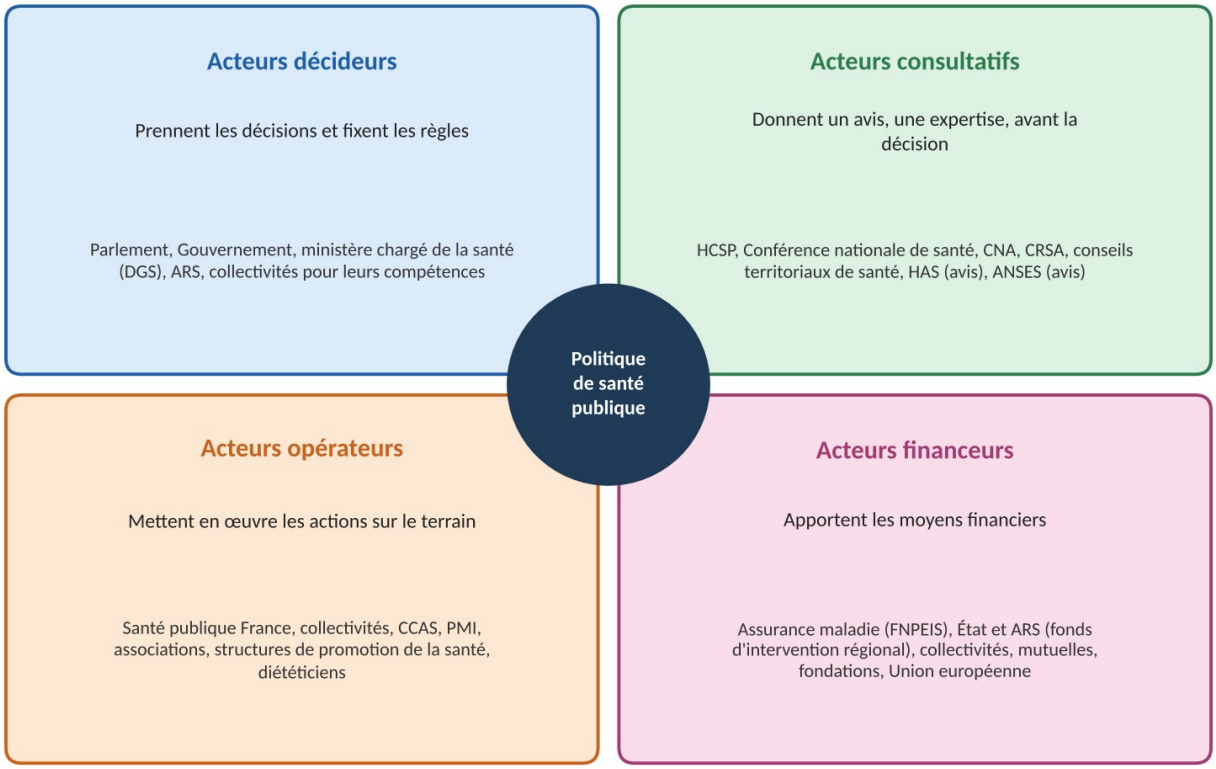


Figure 1.8 bis – Les quatre types d'acteurs d'une politique de santé publique

Comprendre le schéma – Figure 1.8 bis

1. Au centre, la **politique de santé publique** : elle a besoin des quatre types d'acteurs pour exister.
2. **En bleu, les décideurs** : ils sont à l'origine des décisions (lois, plans, arrêtés, choix des priorités).
3. **En vert, les consultatifs** : ils sont consultés **avant** la décision ; ils rendent des avis, des rapports, des recommandations.
4. **En orange, les opérateurs** : ils **mettent en œuvre** la politique décidée, sur le terrain. Le diététicien est un opérateur.
5. **En rose, les financeurs** : ils apportent les crédits (subventions, appels à projets, remboursements).
6. Pour un projet de stage, identifiez au moins un acteur de chaque couleur : c'est la base des **partenariats** (C3.3).

Type d'acteur	Définition (CNED)	Exemples nationaux	Exemples régionaux et locaux
Décideur	Est à l'origine des décisions	Parlement (lois), Gouvernement, ministère chargé de la santé (Direction générale de la santé), ministère de l'Agriculture (Direction générale de l'alimentation)	ARS (projet régional de santé), conseil départemental (PMI), commune (restauration scolaire)
Consultatif	Est consulté pour prendre des décisions	Haut Conseil de la santé publique (HCSP), Conférence nationale de santé (CNS), Conseil national de l'alimentation (CNA)	Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA), conseils territoriaux de santé

Type d'acteur	Définition (CNED)	Exemples nationaux	Exemples régionaux et locaux
Opérateur	Met en œuvre la politique décidée	Santé publique France, Assurance maladie (actions de prévention), associations nationales	Collectivités, CCAS, PMI, écoles, centres sociaux, structures régionales de promotion de la santé, diététiciens, associations locales
Financeur	Apporte les moyens financiers	Assurance maladie (Fonds national de prévention, d'éducation et d'information en santé, FNPEIS), État	ARS (fonds d'intervention régional, FIR), conseils départementaux et régionaux, communes, conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, mutuelles, fondations

Attention – Mettre à jour les sigles des cours anciens

Certains supports citent encore le « Haut **Comité** de santé publique », les « Conférences régionales de santé (CRS) » ou les « territoires de santé ». Depuis la loi du 9 août 2004, on parle du **Haut Conseil de la santé publique (HCSP)** ; depuis la loi HPST de 2009, de la **CRSA** ; depuis la loi du 26 janvier 2016, des **territoires de démocratie sanitaire** et des **conseils territoriaux de santé**. Utiliser le sigle à jour montre au jury que vos sources sont actualisées (C3.4).

À vous de jouer – Exercice d'application 1.3 bis – Identifier le rôle des acteurs d'un projet

Le projet « Petits déjeuners pour tous » d'une ville de 25 000 habitants réunit : l'ARS (qui a lancé l'appel à projets et verse 6 000 €), la CRSA (qui a rendu un avis favorable sur le PRS où figure la priorité « nutrition des enfants »), la commune (qui décide d'offrir le petit déjeuner dans 4 écoles et apporte 9 000 €), l'association « Bouge et mange » (qui anime les ateliers), une diététicienne libérale (qui conçoit les menus) et une mutuelle (2 500 €).

1. Classez chaque acteur selon la typologie (un acteur peut avoir deux rôles).
2. Calculez la part de chaque financeur dans le budget total.

Corrigé – Exercice 1.3 bis

1. **ARS** : décideur (elle arrête le PRS et choisit les projets retenus) et financeur. **CRSA** : consultatif. **Commune** : décideur (pour l'école) et financeur. **Association** : opérateur. **Diététicienne** : opérateur. **Mutuelle** : financeur.
2. Budget total : 6 000 + 9 000 + 2 500 = **17 500 €**. ARS : 6 000 / 17 500 = **34,3 %** ; commune : 9 000 / 17 500 = **51,4 %** ; mutuelle : 2 500 / 17 500 = **14,3 %**. Vérification : 34,3 + 51,4 + 14,3 = 100,0 %.

Le niveau international

Organisme	Rôle en nutrition
OMS – Organisation mondiale de la santé (Genève, 1948)	Agence de l'ONU pour la santé ; définit des normes et recommandations (sucres libres < 10 % de l'apport énergétique, idéalement < 5 % – 2015 ; sel < 5 g/jour ; allaitement exclusif 6 mois) ; plan d'action mondial contre les maladies non transmissibles ; Bureau régional de l'Europe (Copenhague)
FAO – Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Rome, 1945)	Sécurité alimentaire mondiale, systèmes alimentaires durables ; avec l'OMS : Conférences internationales sur la nutrition (CIN2, Rome 2014) ; Décennie d'action des Nations unies pour la nutrition (2016-2025)

Organisme	Rôle en nutrition
Codex alimentarius (FAO/OMS, 1963)	Normes alimentaires internationales (étiquetage, additifs, hygiène, contaminants)
UNICEF	Nutrition de l'enfant et de la mère ; promotion de l'allaitement (initiative « Hôpital ami des bébés » avec l'OMS)
ONU – Objectifs de développement durable (2015- 2030)	ODD 2 « Faim zéro », ODD 3 « Bonne santé et bien-être », ODD 12 « Consommation et production responsables »
Quadripartite One Health	OMS, FAO, OMSA (ex-OIE) et PNUE : plan d'action conjoint « Une seule santé » 2022-2026

Le niveau européen

Organisme	Rôle en nutrition
Commission européenne (DG SANTE)	Propose la réglementation alimentaire (règlement INCO n° 1169/2011 sur l'information des consommateurs : déclaration nutritionnelle obligatoire, 14 allergènes ; règlement n° 1924/2006 sur les allégations nutritionnelles et de santé)
EFSA – Autorité européenne de sécurité des aliments (Parme, 2002)	Évaluation scientifique des risques alimentaires ; valeurs nutritionnelles de référence (Dietary Reference Values) ; avis sur les allégations, additifs, contaminants
Système d'alerte rapide (RASFF)	Échange d'alertes sur les denrées dangereuses entre États membres
EUFIC	Information des consommateurs sur l'alimentation (organisme financé en partie par l'industrie : vérifier les conflits d'intérêts)

Le niveau national

Acteur	Rôle
Ministère chargé de la Santé – Direction générale de la santé (DGS)	Pilote la politique de santé publique et le PNNS ; prépare les lois et règlements ; coordonne les agences
Ministère chargé de l'Agriculture – Direction générale de l'alimentation (DGAL)	Pilote le PNA et la sécurité sanitaire des aliments (contrôles, alertes) ; restauration collective (EGalim, plateforme « ma cantine »)
Ministère de l'Économie – DGCCRF	Loyauté des pratiques commerciales, étiquetage, allégations, sécurité des produits ; RappelConso (avec la DGAL)
Ministère de l'Éducation nationale	Éducation à l'alimentation dans les programmes, santé scolaire, restauration scolaire (avec les collectivités), « Écoles promotrices de santé »
Ministère de la Transition écologique	Copilote de la SNANC ; lutte contre le gaspillage (loi AGEC)
Santé publique France (2016)	Surveillance, veille et alerte ; prévention et promotion de la santé ; programme « Manger Bouger » ; Nutri-Score (gestion du logo en France) ; registre des interventions probantes ; données (Géodes)
ANSES – Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (2010)	Évaluation des risques ; références nutritionnelles (ANC puis RNP, actualisation des repères 2016-2021) ; études INCA ; table Ciqual de composition des aliments ; observatoire Oqali (avec INRAE) ; nutrivigilance

Acteur	Rôle
HAS – Haute Autorité de santé (2004)	Recommandations de bonne pratique (surpoids et obésité de l'enfant 2022 et de l'adulte, dénutrition 2019 et 2021), ETP, évaluation des pratiques
HCSP – Haut Conseil de la santé publique (2004)	Expertise pour la décision publique ; avis sur les repères alimentaires (2017 adultes, 2020 enfants) ; recommandations pour le PNNS 5 (juin 2025) ; évaluation des plans
CNA – Conseil national de l'alimentation (1985)	Instance consultative de concertation entre acteurs (production, transformation, distribution, consommateurs, santé) ; avis (n° 90 sur les nouveaux comportements alimentaires)
INCa – Institut national du cancer	Prévention nutritionnelle des cancers (avec le réseau NACRe)
Assurance maladie (CNAM, CPAM)	Prévention (examens de prévention, « Mission : retrouve ton cap »), financement d'actions, données du SNDS
Recherche : Inserm, INRAE, universités, EREN (équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle)	Production de connaissances ; cohorte NutriNet-Santé (EREN, depuis 2009)
Producteurs de données statistiques : Insee, Drees, CépiDc (Inserm), FNORS et ORS, Crédoc	Données démographiques, sociales, de mortalité (causes de décès), d'état de santé, de consommation

Le niveau régional

Acteur	Rôle
ARS – Agence régionale de santé (loi HPST du 21 juillet 2009, créées en 2010)	Pilote la politique de santé en région : élabore le projet régional de santé (PRS), finance des actions de prévention (fonds d'intervention régional, FIR), lance des appels à projets (nutrition, précarité, ETP), signe les contrats locaux de santé, autorise les établissements, reçoit les déclarations des programmes d'ETP, coordonne la veille sanitaire (signalements, TIAC)
CRSA – Conférence régionale de la santé et de l'autonomie	« Parlement régional de la santé » : donne un avis sur le PRS
DRAAF – Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt	Déclinaison régionale du PNA ; reconnaissance et financement des projets alimentaires territoriaux (PAT) ; appels à projets PNA
DREETS / DDETS	Cohésion sociale, aide alimentaire (programme « Mieux manger pour tous », depuis 2023)
Conseil régional	Lycées (restauration), formation, agriculture, aménagement
Promotion Santé (structures régionales, ex-IREPS)	Appui méthodologique aux porteurs de projets, formation, centres de ressources documentaires, outils pédagogiques
ORS – Observatoire régional de la santé	Diagnostics et portraits de territoire, indicateurs locaux
Dispositifs régionaux d'appui : réseaux de prévention, CSO (centres spécialisés de l'obésité)	Appui aux professionnels, filières de soins

Le niveau départemental et local

Acteur	Rôle
Conseil départemental	Protection maternelle et infantile (PMI) ; action sociale ; aide aux personnes âgées (APA) et en situation de handicap ; collèges (restauration)

Acteur	Rôle
Communes et intercommunalités	Restauration scolaire (écoles primaires), CCAS (centres communaux d'action sociale : épiceries sociales, aide alimentaire, portage de repas), ateliers santé ville, contrats locaux de santé, PAT, politique de la ville (contrats de ville des quartiers prioritaires, « Engagements Quartiers 2030 »)
CAF – Caisse d'allocations familiales	Financement des centres sociaux (agrément « animation collective familles »), soutien à la parentalité
Éducation nationale et services de santé scolaire	Infirmiers, médecins scolaires ; comités d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement (CESCE)
Professionnels de santé de ville	Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS, mission de prévention), centres de santé
Associations	Banques alimentaires, Restos du cœur, Secours populaire, Croix-Rouge ; associations de patients ; associations sportives ; associations d'éducation populaire ; jardins partagés
Entreprises et mutuelles	Santé au travail, restauration d'entreprise, actions de prévention des mutuelles
Diététiciens-nutritionnistes	Libéraux, salariés de collectivités, de centres sociaux, d'associations, de mutuelles, de réseaux ; chargés de missions de santé publique (référentiel du BTS 2024)

Lien diététique – Trouver les acteurs de son lieu de stage

Dès la première semaine de stage, établissez une **carte des acteurs** (fiche F1, rubrique « ressources du territoire ») : ARS et sa délégation départementale, contrat local de santé de la commune, PAT du territoire, contrat de ville si le quartier est prioritaire, structure régionale Promotion Santé, ORS, PMI, CCAS, centres sociaux, épiceries solidaires, associations. Ce travail nourrit le diagnostic, le choix des partenaires et la recherche de financements.

À retenir – Organismes de recueil et de production de données (à connaître pour l'examen)

Insee (démographie, revenus, pauvreté, recensement) ; **Drees** (état de santé, enquêtes de santé scolaire, établissements) ; **CépiDc-Inserm** (causes médicales de décès) ; **Santé publique France** (surveillance, ESTEBAN, Baromètre, Géodes, Albane) ; **ANSES** (INCA, Ciqual, Oqali) ; **Assurance maladie** (SNDS : consommations de soins, ALD) ; **ORS/FNORS** (diagnostics locaux, Score-santé) ; **Crédoc** (consommation, précarité alimentaire) ; **Inserm/EREN** (NutriNet-Santé). Leur fonctionnement et l'exploitation de leurs données sont détaillés aux chapitres 2 et 17.

La démocratie sanitaire : la place des usagers

Définition – Démocratie sanitaire

Démarche qui vise à **associer l'ensemble des acteurs du système de santé**, et en particulier les **usagers** (patients, habitants, associations), à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de santé, dans un esprit de dialogue et de concertation (définition du ministère chargé de la santé).

La **loi n° 2002-303 du 4 mars 2002** relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite **loi Kouchner**, est le texte fondateur. Elle répond à une crise de confiance née d'affaires sanitaires (sang contaminé

dans les années 1980). Elle reconnaît aux malades et à leurs associations deux catégories de droits, complétées par la loi HPST de 2009 et par la loi du 26 janvier 2016.

Droits individuels (reconnus à toute personne dans sa relation avec le système de santé)	Droits collectifs (reconnus aux usagers en tant que groupe)
Accès aux soins et à la prévention, sans discrimination	Représentation des usagers par des **associations agréées**
Respect de la dignité et de la vie privée ; secret des informations	Présence de représentants des usagers dans les instances des établissements (commission des usagers)
Information sur son état de santé ; **consentement libre et éclairé**	Participation aux instances consultatives nationales, régionales et territoriales
Accès direct à son dossier médical	Participation à l'élaboration des politiques de santé (avis sur le PRS, débats publics)
Prise en charge de la douleur ; désignation d'une personne de confiance	Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, **France Assos Santé** (créée par la loi de 2016, active depuis 2017)

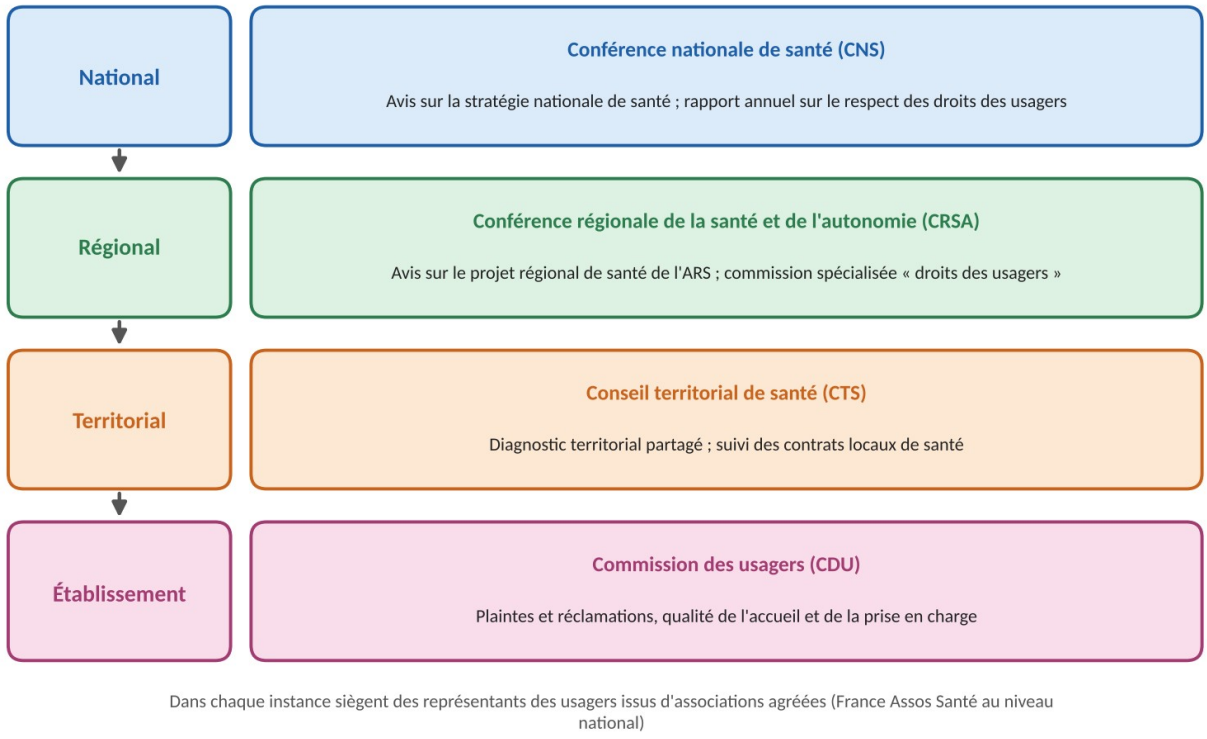


Figure 1.8 ter – Les instances de la démocratie sanitaire, du national à l'établissement

Comprendre le schéma – Figure 1.8 ter

1. Chaque **niveau** du système de santé (à gauche) a son instance de concertation (à droite).
2. **National** : la Conférence nationale de santé donne son avis sur la stratégie nationale de santé et rend chaque année un rapport sur le respect des droits des usagers.
3. **Régional** : la CRSA, créée par la loi HPST, donne son avis sur le projet régional de santé de l'ARS.
4. **Territorial** : le conseil territorial de santé, créé par la loi de 2016, participe au diagnostic territorial partagé et suit les contrats locaux de santé.
5. **Établissement** : la commission des usagers (CDU) examine les plaintes et propose des améliorations de l'accueil et de la prise en charge.
6. Les flèches indiquent la déclinaison du national vers le local ; dans toutes ces instances siègent des représentants des usagers.

Lien diététique – Pourquoi la démocratie sanitaire concerne le diététicien en santé publique

La démocratie sanitaire justifie la **participation des habitants** à toutes les étapes d'un projet : recueil des besoins exprimés, choix des recettes d'un atelier, évaluation. Le principe de **participation** de la Charte d'Ottawa et la démocratie sanitaire vont dans le même sens. À l'oral, dire « j'ai associé deux mères de famille au comité de pilotage » est un argument fort.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.3 ter – Droits individuels ou collectifs ?

Classez chaque situation et nommez l'instance ou le droit concerné.

a) Une patiente demande à lire les comptes rendus de ses consultations diététiques à l'hôpital.

b) L'association départementale des diabétiques désigne un représentant pour siéger à la commission des usagers de l'hôpital.

c) La CRSA rend un avis sur le projet régional de santé 2023-2028.

d) Un résident d'EHPAD refuse l'enrichissement de ses repas après avoir reçu des explications.

Corrigé – Exercice 1.3 ter

a) **Droit individuel** : accès direct au dossier médical (loi du 4 mars 2002). Les transmissions diététiques font partie du dossier.

b) **Droit collectif** : représentation des usagers par une association agréée au sein de la **commission des usagers**.

c) **Droit collectif** : participation à l'élaboration de la politique régionale via une instance consultative, la **CRSA**.

d) **Droit individuel** : consentement libre et éclairé ; le refus doit être respecté, tracé, et la proposition renouvelée sous une autre forme (chapitre 6, éthique).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 1.3.5 – Les acteurs

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre types d'acteurs selon le CNED et donnez un exemple de chacun.
2. Quel organisme pilote la veille sanitaire en France ? Depuis quand ?
3. Quel organisme évalue les risques sanitaires liés à l'alimentation et gère la table Ciqual ?
4. Citez trois droits individuels et deux droits collectifs reconnus par la loi du 4 mars 2002.
5. Nommez l'instance de démocratie sanitaire au niveau national, régional, territorial et dans un hôpital.
6. Calcul : un projet reçoit 4 200 € de l'ARS, 2 800 € de la commune et 1 000 € d'une fondation. Quelle est la part de l'ARS ?

Corrigé – Point d'étape 1.3.5

1. Décideur : ARS, ministère. Consultatif : HCSP, CNS, CRSA. Opérateur : Santé publique France, associations, diététicien. Financeur : Assurance maladie, ARS (fonds d'intervention régional), collectivités.
2. Santé publique France, créée le 1er mai 2016 (regroupement de l'InVS, de l'INPES, de l'EPRUS et d'Adalis).
3. L'ANSES (créée en 2010).
4. Individuels : accès aux soins ; information et consentement libre et éclairé ; accès direct au dossier médical ; secret ; prise en charge de la douleur. Collectifs : représentation par des associations agréées ; présence dans les instances (commission des usagers, CRSA, CNS).
5. National : Conférence nationale de santé. Régional : CRSA. Territorial : conseil territorial de santé. Hôpital : commission des usagers.

6. Total : 4 200 + 2 800 + 1 000 = 8 000 €. Part de l'ARS : 4 200 / 8 000 × 100 = 52,5 %.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

1.3.6 Les politiques publiques de santé : élaboration, pilotage, mise en œuvre et déclinaison territoriale

Module · Référentiel : activité 3.1 · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S2 §1.1 (p. 8) ; Essentiels M1 S3 §1.1 et §1.2 (p. 13 et 14) ; Essentiels M1 S3 §1.3 et §1.4 (p. 14 et 15) ; Essentiels M1 S3 §2 et §3 (p. 16)

Qu'est-ce qu'une politique publique de santé ?

Définition – Politique publique

Ensemble coordonné de décisions et d'actions conduites par les pouvoirs publics (État, collectivités) pour répondre à un **problème reconnu comme public**, avec des **objectifs**, des **moyens** (juridiques, financiers, humains) et des **acteurs** chargés de sa mise en œuvre. Elle se traduit par des **lois**, des **stratégies**, des **plans** ou **programmes**, des **règlements** et des **financements**.

Outil	Définition	Exemples en nutrition
Loi	Texte voté par le Parlement, de portée générale et obligatoire	Loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (création des distributeurs interdits dans les écoles, inscription du PNNS) ; loi EGalim (2018) ; loi Climat et résilience (2021)
Règlement (décret, arrêté)	Texte du Gouvernement ou d'un ministre qui précise l'application d'une loi	Arrêté du 31 octobre 2017 sur le Nutri-Score, modifié par l'arrêté du 14 mars 2025 (nouvel algorithme) ; décret du 30 septembre 2011 sur la qualité nutritionnelle des repas scolaires
Stratégie	Cadre pluriannuel qui fixe les grandes orientations et priorités	Stratégie nationale de santé (dernière adoptée : 2018-2022) ; SNANC 2025-2030
Plan ou programme	Déclinaison opérationnelle d'une stratégie, avec des actions, des pilotes, un calendrier, des indicateurs	PNNS 5 2026-2030 ; PNA 4 2026-2030
Financement	Crédits attribués aux acteurs	Fonds d'intervention régional des ARS ; appels à projets PNA ; programme « Mieux manger pour tous »

Les étapes d'une politique publique

1. Mise à l'agenda : un problème devient « public » sous l'effet de données (surveillance épidémiologique), d'alertes d'experts (avis du HCSP), de médias, d'associations, d'événements (crise sanitaire). Exemple : l'augmentation de la prévalence de l'obésité infantile dans les années 1990 conduit au premier PNNS en 2001.

2. Élaboration : diagnostic, consultation des experts (HCSP, ANSES, CNA), concertation des parties prenantes, consultation publique (le projet de SNS 2023-2033 a fait l'objet d'une consultation publique à l'automne 2023 ; il n'était pas encore adopté en mai 2026), arbitrages interministériels.

3. Décision et adoption : loi, décret, publication d'une stratégie ou d'un programme.

4. Mise en œuvre : par les administrations centrales, les agences, les **ARS** et les collectivités, avec des **financements** et des **partenaires** (associations, professionnels).

5. Pilotage et suivi : comités de pilotage, indicateurs, tableaux de bord, rapports annuels.

6. Évaluation : par des instances indépendantes (HCSP, Inspection générale des affaires sociales – IGAS, Cour des comptes) ; elle prépare le plan suivant. Exemple : l'évaluation du PNNS 4 et l'avis du HCSP de juin 2025 ont servi à construire le PNNS 5.

L'organisation de la politique de santé en France

- **La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé** a fait de la **prévention** et de la **promotion de la santé** des priorités de la politique de santé et a créé le **Nutri-Score** (article 14 : possibilité d'un étiquetage nutritionnel simplifié, facultatif).
- **La Stratégie nationale de santé (SNS)** (article L. 1411-1-1 du Code de la santé publique) fixe les priorités de la politique de santé pour plusieurs années. La dernière SNS adoptée couvre **2018-2022** (décret du 29 décembre 2017). Le **projet de SNS 2023-2033**, soumis à consultation à l'automne 2023, met l'accent sur la prévention tout au long de la vie, l'accès aux soins, la réduction des inégalités et la santé environnementale (« Une seule santé ») ; selon une réponse du ministère publiée au *Journal officiel* le 12 mai 2026, il n'avait pas encore été adopté par le Gouvernement. Dans un dossier, on s'appuie donc sur la SNANC 2025-2030 et le PNNS 5, et l'on présente la SNS 2023-2033 comme un projet.
- **Le Comité interministériel pour la santé** (créé en 2014) coordonne les politiques des différents ministères ayant un impact sur la santé.
- **Les agences sanitaires** (Santé publique France, ANSES, HAS) apportent l'expertise et la mise en œuvre opérationnelle.

Priorités, programmes et planification sanitaire

Définition – Les mots de la planification

Priorité sanitaire : décision des pouvoirs publics de mettre en place des mesures pour résoudre un problème de santé identifié (par exemple, le surpoids des enfants).

Plan ou **programme** : ensemble organisé d'actions, avec des objectifs, des acteurs, des partenaires, des moyens et un calendrier, pour atteindre un objectif commun (le PNNS est un programme ; les plans nationaux durent en général 4 à 5 ans).

Planification sanitaire : démarche qui consiste à **prévoir** les actions à mener pour atteindre des objectifs de santé, **selon un ordre de priorité**, en adaptant l'offre de soins et de prévention aux besoins de la population. Elle doit respecter le cadre fixé par la **stratégie nationale de santé** ; dans chaque région, c'est l'ARS qui la conduit au travers du PRS.

Territoire de démocratie sanitaire : découpage de la région, arrêté par l'ARS depuis la loi du 26 janvier 2016, à l'échelle duquel siège un conseil territorial de santé. Il a remplacé les anciens « territoires de santé ».

Méthode – La logique descendante et la logique ascendante

La planification est **descendante** : la SNS fixe les priorités, le PRS les décline, le contrat local de santé les traduit en fiches-actions. Mais elle est aussi **ascendante** : les diagnostics locaux (diagnostic territorial partagé, observatoire régional de santé) remontent les besoins, et les instances de démocratie sanitaire donnent leur avis. Un bon projet de stage montre les **deux logiques** : « mon action répond à la priorité n° X du PRS » (descendant) et « elle répond aux besoins exprimés par les habitants » (ascendant).

Les données qui éclairent les politiques de santé

Une politique se décide à partir de données. Les grands producteurs de données et les enquêtes nutritionnelles sont étudiés au chapitre 17. Retenez ici deux dispositifs souvent cités dans les cours.

Dispositif	Ce que c'est	Intérêt pour la santé publique
Système national des données de santé (SNDS)	Base qui rassemble, depuis la loi du 26 janvier 2016, les données de l'Assurance maladie (remboursements, SNIIRAM), des hôpitaux (PMSI) et les causes médicales de décès (Inserm-CépiDc) ; il est géré par la Caisse nationale de l'Assurance maladie (Cnam)	Connaître le recours aux soins, le nombre de personnes traitées pour un diabète, l'évolution d'une maladie dans un territoire
Plateforme des données de santé (Health Data Hub)	Groupement d'intérêt public créé par la loi du 24 juillet 2019 ; il a remplacé l'Institut national des données de santé (INDS, 2017-2019)	Faciliter l'accès sécurisé des chercheurs et des agences aux données de santé, dans le respect du RGPD (chapitre 20)

Attention – Une donnée de remboursement n'est pas une donnée de santé complète

Le SNDS compte les personnes **traitées** et **remboursées**. Une personne diabétique non diagnostiquée, ou qui ne consulte pas, n'y figure pas. Pour l'obésité, qui ne donne pas lieu à un remboursement spécifique, on utilise surtout des **enquêtes** (Esteban, OFÉO, santé scolaire). Il faut toujours dire **d'où vient** un chiffre et **ce qu'il mesure** (C3.4).

La déclinaison territoriale

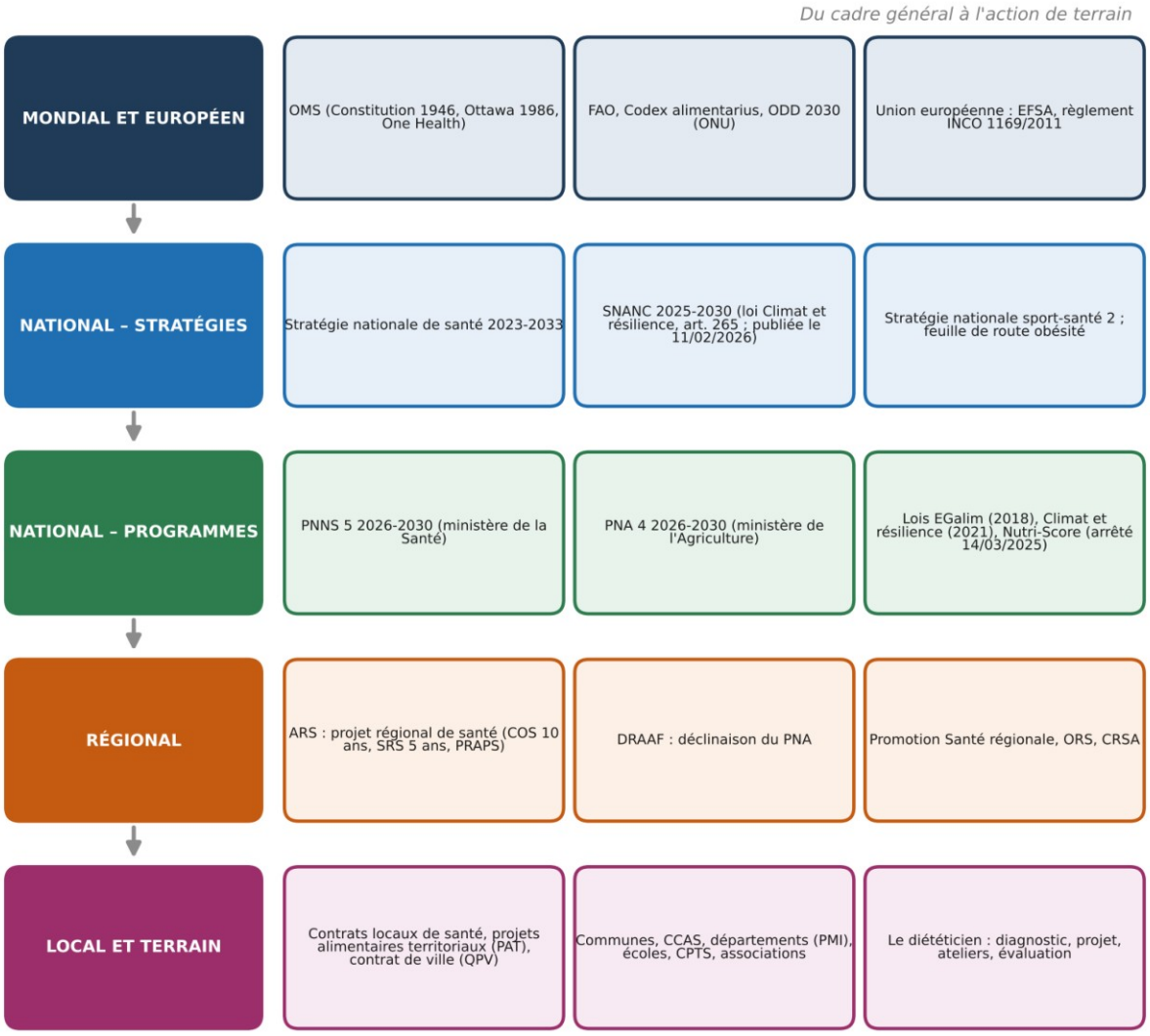


Figure 1.9 – De la stratégie internationale à l'action de terrain : architecture des politiques nutritionnelles en 2026

Comprendre le schéma – Figure 1.9

1. Mondial et européen : l'OMS, la FAO, les ODD et l'Union européenne fixent un cadre (définitions, recommandations, réglementation de l'étiquetage).

2. National – stratégies : la SNS fixe les priorités de santé (dernière adoptée : 2018-2022 ; projet 2023-2033 non adopté en mai 2026) ; la SNANC 2025-2030 relie alimentation, nutrition et climat ; d'autres stratégies complètent (sport-santé, obésité).

3. National – programmes : le PNNS 5 (Santé) et le PNA 4 (Agriculture) déclinent la SNANC en actions ; les lois (EGalim, Climat et résilience) et les règlements (Nutri-Score) les rendent obligatoires.

4. Régional : l'ARS traduit ces orientations dans le PRS ; la DRAAF décline le PNA ; les structures régionales de promotion de la santé et l'ORS apportent l'appui méthodologique et les données.

5. Local et terrain : contrats locaux de santé, PAT, contrats de ville, communes, CCAS, PMI, écoles, CPTS et associations mettent en œuvre ; le diététicien conçoit et anime les actions et les évalue.

6. Les flèches montrent que chaque niveau **s'appuie** sur le niveau supérieur : en stage, vous devez pouvoir relier votre action locale à ces différents textes.

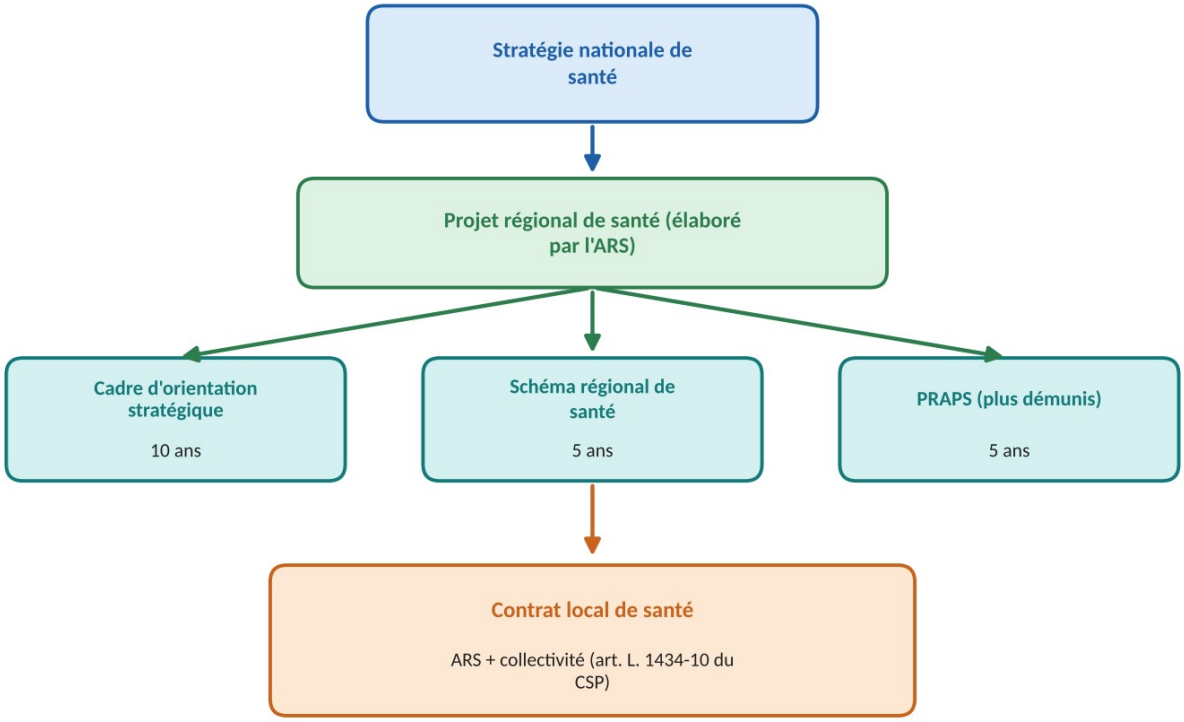


Figure 1.9 bis – De la stratégie nationale au contrat local de santé

Comprendre le schéma – Figure 1.9 bis

1. En haut, la **stratégie nationale de santé** fixe les priorités (dernière adoptée : 2018-2022 ; le projet 2023-2033 n'était pas adopté en mai 2026).
2. Chaque **ARS** élabore un **projet régional de santé** qui la décline dans la région.
3. Le PRS comprend trois documents : le **cadre d'orientation stratégique** (10 ans), le **schéma régional de santé** (5 ans) et le **PRAPS** pour les plus démunis (5 ans).
4. En bas, le **contrat local de santé** est signé entre l'ARS et une collectivité ; il traduit le PRS en fiches-actions sur un territoire (article L. 1434-10 du Code de la santé publique).
5. Un projet de stage cite au moins le **niveau régional** (objectif du PRS) et, s'il existe, le **CLS** du territoire.

Dispositif	Contenu
Projet régional de santé (PRS) – art. L. 1434-1 CSP	Élaboré par l'ARS ; comprend un cadre d'orientation stratégique (COS) sur 10 ans, un schéma régional de santé (SRS) sur 5 ans (prévention, offre de soins, médico-social) et un programme régional d'accès à la prévention et aux soins des plus démunis (PRAPS). Les PRS dits « de 3e génération » couvrent généralement la période 2023-2028 (COS jusqu'en 2033)
Contrat local de santé (CLS) – art. L. 1434-10 CSP	Contrat entre l'ARS et une collectivité (commune, intercommunalité) pour mettre en œuvre le PRS au plus près des habitants ; volet nutrition fréquent
Projet alimentaire territorial (PAT) – loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014	Démarche collective qui rapproche producteurs, transformateurs, distributeurs, collectivités et consommateurs pour développer une alimentation locale, durable et accessible ; reconnu par le ministère de l'Agriculture ; au 1er juillet 2025, environ 450 PAT étaient reconnus et la SNANC fixe l'objectif d'au moins 80 % du territoire couvert

Dispositif	Contenu
Contrat de ville (politique de la ville)	Concerne les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ; nouvelle génération « Engagements Quartiers 2030 » (2024-2030) ; volet santé souvent porté par un atelier santé ville (ASV)
Conseil local de santé mentale, CPTS, MSP	Coordination des acteurs de santé de proximité

Exemple – Comment une orientation nationale devient une action dans un quartier

1. National : le PNNS 5 (2026-2030) fait de la réduction des inégalités sociales en nutrition et de la santé des enfants des priorités ; il se donne pour objectif de réduire de 30 % la prévalence du surpoids et de l'obésité des enfants et adolescents (20 % chez ceux issus de familles défavorisées).

2. Régional : le PRS de l'ARS inscrit la nutrition des enfants dans les quartiers prioritaires parmi ses priorités de prévention et lance chaque année un **appel à projets** « prévention – promotion de la santé ».

3. Local : le contrat local de santé de la commune de Valmont (fictive) prévoit une fiche-action « Bien manger dans les quartiers ».

4. Terrain : le centre social des Tilleuls répond à l'appel à projets avec l'appui d'une diététicienne et d'une stagiaire de BTS ; il obtient une subvention de 1 500 € (cas fil rouge, fiche F4).

À vous de jouer – Exercice d'application 1.4

Pour votre futur lieu de stage (ou, à défaut, pour votre commune), recherchez sur internet : a) le PRS de votre région et l'objectif qui concerne la nutrition ; b) l'existence d'un contrat local de santé ; c) l'existence d'un PAT ; d) la présence de quartiers prioritaires (site de l'ANCT, *sig.ville.gouv.fr*). Présentez le résultat dans un tableau de 4 lignes : dispositif / existe ? / référence (titre, date) / ce qui concerne la nutrition.

Corrigé – Méthode de correction

- Le PRS se trouve sur le site de l'ARS (rubrique « Projet régional de santé ») ; repérez dans le **SRS** le chapitre « prévention » ou « nutrition » et notez l'objectif précis, avec sa date.
- Les CLS sont listés sur le site de l'ARS ou de la collectivité ; vérifiez qu'il est **en cours** (dates de début et de fin).
- Les PAT sont recensés sur le site du ministère de l'Agriculture et sur France PAT (Réseau national des PAT, RnPAT).
- Les QPV se vérifient sur le système d'information géographique de la politique de la ville (*sig.ville.gouv.fr*), à partir d'une adresse.
- Exemple de ligne rédigée : « CLS de Valmont 2024-2028 – oui – fiche-action 3 "Bien manger dans les quartiers" – actions d'éducation alimentaire dans les centres sociaux, financement ARS. » Chaque ligne doit comporter un **titre**, une **date** et une **source** : c'est l'attendu de l'indicateur « sources d'informations fiables repérées et connues » (C3.4).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 1.3.6 – Politiques publiques et territoires

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les étapes d'une politique publique.
2. Que fixe la stratégie nationale de santé ? Où en est la SNS 2023-2033 ?
3. Citez les trois composantes du projet régional de santé et leur durée.
4. Qu'est-ce qu'un contrat local de santé ? Qui le signe ?
5. Définissez la planification sanitaire.

6. Vrai ou faux : « Le SNDS permet de connaître le nombre exact de personnes en situation d'obésité. » Justifiez.

Corrigé – Point d'étape 1.3.6

1. Mise à l'agenda ; élaboration ; décision et adoption ; mise en œuvre ; pilotage et suivi ; évaluation (qui prépare le plan suivant).

2. Elle fixe les priorités de la politique de santé ; la dernière adoptée couvre 2018-2022, et le projet 2023-2033 n'était pas encore adopté en mai 2026.

3. Cadre d'orientation stratégique (10 ans), schéma régional de santé (5 ans), programme régional d'accès à la prévention et aux soins des plus démunis (PRAPS).

4. Un contrat entre l'ARS et une collectivité (commune ou intercommunalité) pour mettre en œuvre le PRS au plus près des habitants.

5. Démarche qui consiste à prévoir les actions à mener pour atteindre des objectifs de santé, selon un ordre de priorité, dans le cadre de la stratégie nationale de santé.

6. Faux : le SNDS contient des données de remboursement et d'hospitalisation ; l'obésité n'est pas repérée par un remboursement spécifique. On utilise des enquêtes (Esteban, OFÉO).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

1.3.7 Les politiques nutritionnelles de santé publique

Module · Référentiel : C3.4 · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Synthèse M3 S1 §2 (p. 29)

Pourquoi une politique nutritionnelle ? Les enjeux en chiffres

La nutrition (alimentation et activité physique) est un **déterminant majeur** des principales maladies chroniques : obésité, diabète de type 2, maladies cardio-neurovasculaires, plusieurs cancers, ostéoporose, et, à l'autre extrémité, dénutrition et carences. Ces maladies sont **fréquentes**, **graves**, **coûteuses** et **socialement inégalitaires** : elles justifient une politique publique.

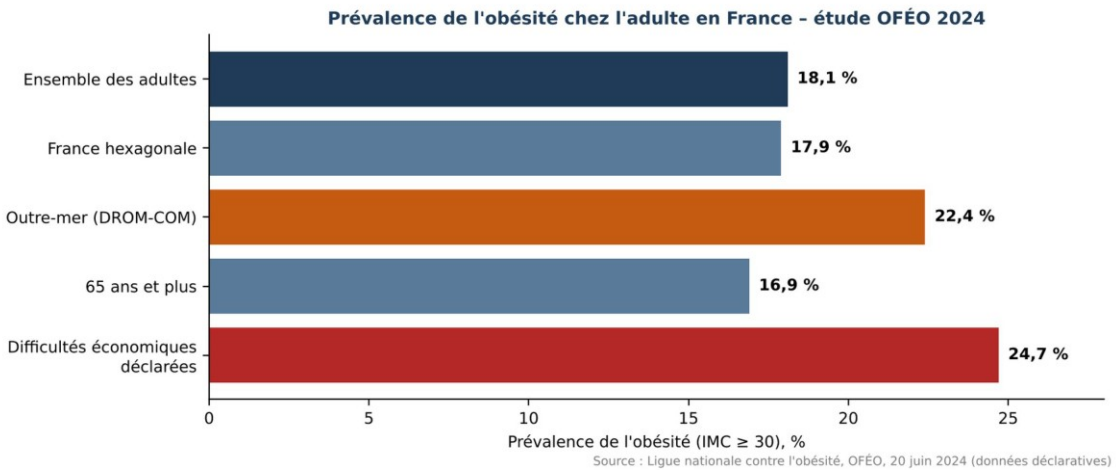


Figure 1.10 – Prévalence de l'obésité chez l'adulte en France selon le territoire, l'âge et la situation économique (OFÉO, 2024)

Comprendre le schéma – Figure 1.10

1. En 2024, **18,1 %** des adultes vivant en France déclarent un IMC ≥ 30 kg/m², soit environ **10 millions** de

personnes (étude OFÉO de la Ligue nationale contre l'obésité, présentée le 20 juin 2024, successeur de l'étude ObÉpi-Roche 2020 qui trouvait 17 %).

2. La prévalence est plus élevée **en outre-mer** (22,4 %) qu'en France hexagonale (17,9 %) : c'est une **inégalité territoriale**.
3. Elle atteint **24,7 %** chez les personnes déclarant des **difficultés économiques** : c'est une **inégalité sociale**.
4. Ces données sont **déclaratives** (poids et taille déclarés), ce qui sous-estime en général la prévalence ; les données **mesurées** de l'étude ESTEBAN (2014-2016) donnaient 17 % d'obésité et 49 % de surpoids (obésité comprise) chez les 18-74 ans.
5. Lecture pour le diététicien : ces écarts justifient le principe d'**universalisme proportionné** et la priorité donnée par le PNNS 5 aux enfants des familles défavorisées et aux territoires ultramarins.

Indicateur	Valeur et source
Obésité de l'adulte (déclarée)	18,1 % en 2024 ; 22,4 % en outre-mer ; 24,7 % en cas de difficultés économiques (OFÉO, Ligue nationale contre l'obésité, juin 2024)
Surpoids (obésité comprise) et obésité mesurés, adultes 18-74 ans	49 % dont 17 % d'obésité (ESTEBAN 2015, Santé publique France, 2017)
Surpoids (obésité comprise) des enfants de 6 à 17 ans	17 % dont 4 % d'obésité (ESTEBAN 2015)
Adultes atteignant les 5 fruits et légumes par jour	environ 30 % des adultes et 20 % des enfants (HCSP, recommandations pour le PNNS 5, juin 2025)
Apports en fibres	90 % des adultes n'atteignent pas 25 g/jour (HCSP, juin 2025)
Viande rouge	4 hommes sur 10 et 1 femme sur 4 dépassent le repère de 500 g par semaine (HCSP, juin 2025)
Sel	Consommation moyenne d'environ 9 g/jour chez l'homme et 7 g/jour chez la femme (INCA 3, ANSES 2017), pour un repère OMS < 5 g/jour
Activité physique des jeunes	42 % des 6-17 ans atteignaient 60 minutes par jour en 2016 ; près d'un adulte sur trois reste assis plus de 7 heures par jour en 2024 (HCSP, juin 2025)
Précarité alimentaire	16 % des Français déclarent ne pas avoir assez à manger (souvent ou parfois) en 2022, contre 9 % en 2016 (Crédoc, 2023)
Espérance de vie à la naissance (2025)	85,9 ans pour les femmes, 80,3 ans pour les hommes (Insee, Bilan démographique 2025, janvier 2026)
Inégalités sociales de mortalité	Environ 13 ans d'écart d'espérance de vie entre les 5 % d'hommes les plus aisés et les 5 % les plus modestes (Insee Première n° 1687, février 2018)
Vieillissement	22,2 % de la population a 65 ans ou plus au 1er janvier 2026 (Insee) : enjeu de prévention de la dénutrition

Attention – Bien lire un chiffre de santé publique

Avant de citer un chiffre dans un dossier, vérifiez : **l'année** de recueil (et pas seulement l'année de publication) ; la **population** (adultes ? 18-74 ans ? France entière ?) ; la **méthode** (mesuré ou déclaré) ; la **source** (institutionnelle, associative, industrielle). Par exemple, 17 % d'obésité (ESTEBAN, mesuré, 2015) et 18,1 % (OFÉO, déclaré, 2024) ne sont pas directement comparables.

Historique : du PNNS 1 au PNNS 5

Période	Repères principaux
2001-2005 – PNNS 1	Lancé en janvier 2001 à la suite des États généraux de l'alimentation (2000) et du rapport du HCSP ; 9 objectifs nutritionnels prioritaires chiffrés (augmenter la consommation de fruits et légumes, de calcium, de glucides complexes et de fibres ; réduire les lipides totaux sous 35 % de l'apport énergétique et les acides gras saturés ; réduire l'alcool, la cholestérolémie, la pression artérielle ; réduire de 20 % l'obésité de l'adulte et stopper l'augmentation chez l'enfant ; augmenter l'activité physique) ; guide « La santé vient en mangeant » (2002)
2004	Loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : le PNNS devient un programme quinquennal inscrit dans la loi ; interdiction des distributeurs automatiques payants de boissons et produits alimentaires dans les établissements scolaires (à partir de 2005) ; messages sanitaires obligatoires sur les publicités alimentaires (« Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour », 2007)
2006-2010 – PNNS 2	Actions sur l'offre alimentaire : chartes d'engagements volontaires de progrès nutritionnel des industriels (2008) ; création de l'Oqali (2008) ; actions auprès des populations défavorisées
2010	Loi de modernisation de l'agriculture du 27 juillet 2010 : création du Programme national pour l'alimentation (PNA) ; Plan obésité 2010-2013
2011-2015 (prolongé jusqu'en 2018) – PNNS 3	Réduction des inégalités sociales de santé en nutrition ; activité physique ; dénutrition ; articulation avec le Plan obésité
2016	Loi de modernisation de notre système de santé : base légale du Nutri-Score (adopté en France par arrêté du 31 octobre 2017)
2017	Avis du HCSP sur la révision des repères alimentaires des adultes (février) ; actualisation des repères par l'ANSES (décembre 2016) ; résultats d'INCA 3 et d'ESTEBAN
2018	Loi EGalim (30 octobre 2018)
2019-2023 – PNNS 4	Lancé en septembre 2019 ; 5 axes, 55 actions ; nouveaux repères alimentaires de Santé publique France (janvier 2019) ; extension du Nutri-Score ; PNA 3 (2019-2023) ; PNNS 4 et PNA 3 réunis dans le Programme national de l'alimentation et de la nutrition (PNAN)
2021	Loi Climat et résilience (22 août 2021) : prévoit une stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat (article 265) ; menu végétarien hebdomadaire pérennisé en restauration scolaire
2025	Avis du HCSP pour le PNNS 5 (juin) ; nouvel algorithme du Nutri-Score (arrêté du 14 mars 2025) ; lancement de l'enquête Albane (juin)
2026	SNANC 2025-2030 publiée le 11 février 2026 ; PNNS 5 et PNA 4 (2026-2030) lancés le 8 avril 2026 au One Health Summit de Lyon

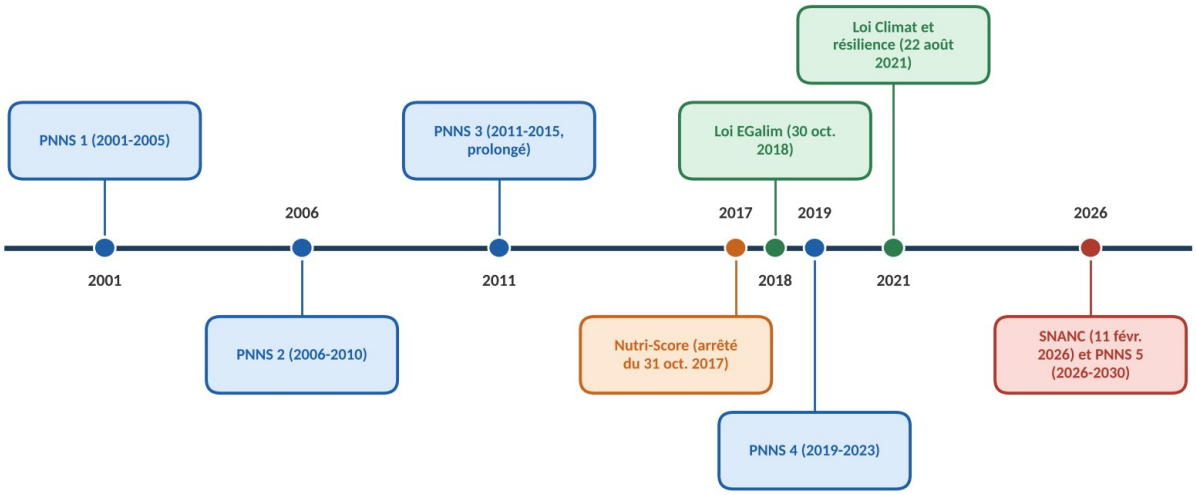


Figure 1.10 bis – Vingt-cinq ans de politiques nutritionnelles en France (2001-2026)

Comprendre le schéma – Figure 1.10 bis

1. En **bleu**, les cinq programmes nationaux nutrition santé : ils se succèdent depuis 2001.
2. En **orange**, le **Nutri-Score**, adopté en France par l'arrêté du 31 octobre 2017.
3. En **vert**, les lois qui agissent sur l'offre alimentaire : **EGalim** (30 octobre 2018) et **Climat et résilience** (22 août 2021).
4. En **rouge**, l'étape actuelle : la **SNANC**, publiée le 11 février 2026, et le **PNNS 5** (2026-2030).
5. La frise montre une évolution : on est passé d'une politique de **messages** (PNNS 1) à une politique qui agit aussi sur l'**environnement alimentaire** et le **climat**.

La Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) 2025-2030

Définition – SNANC

Stratégie prévue par l'**article 265 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021** portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi « Climat et résilience »). Elle fixe les **orientations de la politique de l'alimentation durable**, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine, davantage protectrice de la biodiversité, favorisant la résilience des systèmes agricoles et alimentaires et garante de la souveraineté alimentaire, ainsi que les orientations de la **politique de la nutrition**. Elle détermine les orientations du **PNNS** et du **PNA**. Attendue en 2023, elle a été publiée le **11 février 2026** pour la période **2025-2030**.

La SNANC articule **trois enjeux** : **santé publique**, **transition écologique** et **souveraineté alimentaire**. Elle s'organise autour de trois grands axes (présentation gouvernementale du 11 février 2026) :

1. Permettre à tous l'accès à une alimentation plus saine : renforcer la prévention nutritionnelle, encourager des produits de qualité, diversifiés et durables, lutter contre la précarité alimentaire, améliorer l'information du consommateur.

2. Réduire l'impact de l'alimentation sur le climat : pratiques agricoles durables, réduction du gaspillage alimentaire, relocalisation de certaines productions, adaptation de toute la chaîne alimentaire au changement climatique.

3. Soutenir les agriculteurs et les filières : transition agroécologique, valorisation des productions françaises, résilience et innovation. Elle insiste sur l'**action territoriale** (objectif d'au moins **80 % du territoire couvert par des PAT**) et rappelle les obligations EGalim en restauration collective. Le PNNS 5 et le PNA 4 en sont les **déclinaisons opérationnelles**.

Le Programme national nutrition santé 2026-2030 (PNNS 5)

État de la veille – PNNS 5 – ce qu'il faut savoir (état au 26 octobre 2026)

- **Pilotage** : ministère chargé de la Santé (DGS), en articulation interministérielle avec le PNA 4 ; programme élaboré avec l'IGAS, le CGAAER, le HCSP et une large concertation (ARS, société civile, chercheurs).
- **Trois axes** : 1) « garantir à tous l'accès à des environnements nutritionnels durables favorables à la santé » ; 2) « encourager des comportements nutritionnels sains et durables » ; 3) « faire des milieux de vie des espaces promoteurs de santé » (entreprises, établissements scolaires et d'enseignement supérieur).
- **20 mesures** (contre 55 actions dans le PNNS 4), dont des actions spécifiques pour les **enfants et adolescents** et pour les **territoires ultramarins**.
- **Objectifs chiffrés annoncés** : réduire de **30 %** la prévalence du surpoids et de l'obésité des enfants et adolescents (et de **20 %** chez ceux issus de familles défavorisées) ; atteindre **12 %** de consommation de produits bio ; **40 %** des Français utilisant le Nutri-Score (contre 33 %) et **75 %** du volume des produits transformés affichant le Nutri-Score (contre 62 %) ; **85 %** d'enfants allaités à la naissance.
- **Mesures phares** : protection des enfants face au marketing alimentaire (charte ARCOM 2025-2029, réflexion sur des restrictions autour des écoles) ; accord collectif demandé aux filières pour réduire les **sucres** dans les produits destinés aux enfants (viennoiseries, biscuits) ; Nutri-Score étendu (non-préemballé, restauration hors foyer en test) ; promotion de l'allaitement et alimentation des « 1000 premiers jours » ; prévention de la **dénutrition** des personnes âgées ; **nouvelles recommandations alimentaires saines et durables** pour la population générale et des publics spécifiques (femmes en désir de grossesse, personnes âgées…).
- **Ce qui change** : l'activité physique relève désormais principalement de la **Stratégie nationale sport- santé** et la prise en charge de l'obésité d'une feuille de route dédiée ; les aliments **ultra-transformés** sont reconnus comme un enjeu majeur, l'ANSES étant chargée d'en proposer une définition opérationnelle.

Sources : présentation officielle du 8 avril 2026 et synthèses publiées (Réseau national nutrition santé, Vidal, avril 2026). **À vérifier dans le texte intégral** sur le site du ministère de la Santé ou sur mangerbouger.fr avant toute citation chiffrée dans un dossier.

Le Programme national pour l'alimentation 2026-2030 (PNA 4)

Piloté par le **ministère de l'Agriculture**, le PNA (créé par la loi du 27 juillet 2010, art. L. 1 du Code rural et de la pêche maritime) décline la SNANC sur les volets **offre alimentaire**, **restauration collective**, **lutte contre le gaspillage**, **éducation alimentaire** (notamment à l'école) et **justice sociale** (accès de tous à une alimentation de qualité). Il soutient les **PAT** et lance des **appels à projets** nationaux et régionaux (via les DRAAF) dont peuvent bénéficier des projets d'éducation alimentaire.

Les repères alimentaires en vigueur (adultes)

Les repères de **Santé publique France (janvier 2019)**, issus de l'avis du HCSP (février 2017) et de l'actualisation de l'ANSES (décembre 2016), sont présentés sur **mangerbouger.fr** en trois catégories :

Catégorie	Repères
Augmenter	Fruits et légumes : au moins 5 portions par jour (une portion ≈ 80 à 100 g) ; légumes secs (lentilles, haricots, pois chiches) : au moins 2 fois par semaine ; fruits à coque sans sel ajouté : une petite poignée par jour ; activité physique : au moins 30 minutes d'activité dynamique par jour
Aller vers	Féculents complets (pain, pâtes, riz) : au moins un par jour ; huiles de colza, de noix, d'olive ; poisson : 2 fois par semaine dont 1 poisson gras ; produits laitiers : 2 par jour ; aliments de saison et produits locaux, bio si possible ; fait maison

Catégorie	Repères
Réduire	Alcool : au maximum 10 verres standard par semaine, pas plus de 2 par jour, et des jours sans consommation ; boissons sucrées (sodas, jus de fruits) : au maximum un verre par jour ; produits gras, sucrés, salés et ultra-transformés ; charcuterie : 150 g par semaine maximum ; viande (hors volaille) : 500 g par semaine maximum ; sel ; temps passé assis

Attention – Repères et populations spécifiques

Les repères ci-dessus concernent les **adultes**. Il existe des repères spécifiques pour les **enfants de 0 à 17 ans** (HCSP, juin 2020 ; déclinaisons Santé publique France), les **femmes enceintes et allaitantes** et les **personnes âgées** (ANSES 2019 ; révisions annoncées par le PNNS 5). En atelier, adaptez toujours les messages au public (chapitres 4 et 10).

Les autres leviers réglementaires et programmes

Levier	Contenu
Loi EGalim (n° 2018-938 du 30 octobre 2018) et loi Climat et résilience (2021)	En restauration collective publique (et privée depuis 2024) : au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits bio (en valeur d'achat HT, depuis le 1er janvier 2022) ; depuis le 1er janvier 2024, 60 % de produits durables et de qualité pour les viandes et poissons (100 % pour l'État) ; menu végétarien au moins une fois par semaine en restauration scolaire ; plan pluriannuel de diversification des protéines (plus de 200 couverts par jour) ; information des convives ; lutte contre le gaspillage (diagnostic, dons) ; suppression progressive du plastique. Les achats sont télédéclarés sur la plateforme « ma cantine ». Le bilan publié en 2024 (achats 2023) montrait environ 25,5 % de produits durables et de qualité et 12,1 % de bio : les objectifs ne sont pas atteints
Nutri-Score	Logo nutritionnel à 5 couleurs et lettres (A à E), développé par l'équipe EREN, adopté en France le 31 octobre 2017, facultatif (le droit européen ne permet pas de l'imposer) ; utilisé dans 7 pays (France, Belgique, Espagne, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse) ; nouvel algorithme adopté par le comité de pilotage européen (2022-2023) et rendu applicable en France par l'arrêté du 14 mars 2025, avec 2 ans de transition : meilleur classement des huiles riches en acides gras insaturés (colza, olive, noix), des poissons gras, des céréales complètes ; classement plus sévère des produits salés et sucrés et des boissons édulcorées ; seule l'eau est classée A parmi les boissons
Fiscalité	Contribution sur les boissons sucrées (2012), progressive selon la teneur en sucres depuis 2018, et sur les boissons édulcorées
Encadrement du marketing	Loi du 20 décembre 2016 (suppression de la publicité dans les programmes jeunesse de la télévision publique depuis 2018) ; chartes alimentaires de l'ARCOM (charte 2025-2029)
1000 premiers jours	Programme lancé en 2020 (rapport de la commission présidée par Boris Cyrulnik) : alimentation de la femme enceinte et du jeune enfant, allaitement, accompagnement des parents ; site 1000-premiers-jours.fr
Aide alimentaire	Programme « Mieux manger pour tous » (depuis 2023) : améliorer la qualité nutritionnelle et l'accès à des produits frais et locaux dans l'aide alimentaire ; projets alimentaires de territoire solidaires

Levier	Contenu
Restauration scolaire	Tarification sociale (« cantine à 1 € », 2019) ; petits-déjeuners gratuits dans les écoles des territoires prioritaires (2019) ; programme européen « lait et fruits à l'école »
Labels et chartes PNNS	Collectivités actives PNNS (villes, départements), établissements actifs, entreprises actives ; logo PNNS sur les supports conformes ; Réseau national nutrition santé

Lien diététique – Utiliser les politiques nutritionnelles dans son dossier E5

Dans la partie « contexte » de votre dossier, montrez que votre projet **s'inscrit** dans les politiques en vigueur : citez la **SNANC 2025-2030**, l'axe et l'action du **PNNS 5** concernés, l'objectif du **PRS** de votre région, le **CLS** ou le **PAT** du territoire. Une phrase type : « Ce projet s'inscrit dans l'axe 2 du PNNS 5 (2026-2030), "encourager des comportements nutritionnels sains et durables", et dans l'objectif de réduction des inégalités sociales de santé du PRS de la région… ». Le jury valorise la **cohérence** entre le diagnostic local et ces priorités.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.5 – Calculer un taux EGalim

Une cantine scolaire a acheté sur l'année 120 000 € HT de denrées, dont 18 000 € de produits bio, 21 000 € de produits sous label Rouge ou AOP/IGP (non bio), et 6 000 € de produits issus de la pêche durable (écolabel). Calculez le taux de produits bio et le taux de produits durables et de qualité. La cantine respecte-t-elle la loi EGalim ?

Corrigé

Formule : taux (%) = montant des achats de la catégorie / montant total des achats × 100. **Étape 1 – Taux de bio** : 18 000 / 120 000 × 100 = **15 %**. L'objectif est d'au moins 20 % : **non atteint** (il manque 5 points, soit 0,05 × 120 000 = 6 000 € d'achats bio supplémentaires à budget constant). **Étape 2 – Produits durables et de qualité** (le bio en fait partie) : 18 000 + 21 000 + 6 000 = 45 000 € ; 45 000 / 120 000 × 100 = **37,5 %**. L'objectif est d'au moins 50 % : **non atteint** (il manque 12,5 points, soit 15 000 €). **Interprétation** : la cantine est en progression mais ne respecte pas les deux seuils EGalim ; le diététicien peut proposer de remplacer une partie des achats conventionnels par des produits bio de saison (moins chers en saison) et de financer ces achats par la diversification des protéines (plats à base de légumineuses, moins coûteux) et la réduction du gaspillage.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 1.3.7 – Les politiques nutritionnelles

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les périodes des cinq PNNS.
2. Quelle loi prévoit la SNANC ? Quand la SNANC a-t-elle été publiée ?
3. Quels sont les trois axes du PNNS 5 ?
4. Quelles sont les obligations EGalim en restauration collective (produits durables et bio) ?
5. Citez quatre repères « Augmenter » de Santé publique France.
6. Calcul : un restaurant scolaire achète 82 000 € HT de denrées, dont 15 600 € de produits bio et 23 400 € d'autres produits durables et de qualité. Les objectifs EGalim sont-ils atteints ?

Corrigé – Point d'étape 1.3.7

1. PNNS 1 : 2001-2005 ; PNNS 2 : 2006-2010 ; PNNS 3 : 2011-2015 (prolongé jusqu'en 2018) ; PNNS 4 : 2019-2023 ; PNNS 5 : 2026-2030.

2. La loi Climat et résilience du 22 août 2021 (article 265) ; publication le 11 février 2026.

3. Environnements nutritionnels durables et favorables à la santé ; comportements nutritionnels sains et durables ; mobilisation des milieux de vie et des acteurs clés.

4. Au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits bio, en valeur d'achat HT.

5. Fruits et légumes (au moins 5 par jour) ; légumes secs (au moins 2 fois par semaine) ; fruits à coque sans sel ajouté (une petite poignée par jour) ; activité physique (au moins 30 minutes par jour).

6. Bio : 15 600 / 82 000 × 100 = 19,0 % (objectif de 20 % non atteint). Durables et de qualité, bio compris : (15 600 + 23 400) / 82 000 × 100 = 47,6 % (objectif de 50 % non atteint). Il manque 0,20 × 82 000 − 15 600 = 800 € de bio et 0,50 × 82 000 − 39 000 = 2 000 € de produits durables.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

1.3.8 Le diététicien-nutritionniste en santé publique

Module · Référentiel et guide : voir 1.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 1.2.2)

Le cadre réglementaire de la profession

Définition – Diététicien – article L. 4371-1 du Code de la santé publique

« Est considérée comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui, habituellement, dispense des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l'éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles du métabolisme ou de l'alimentation, par l'établissement d'un bilan diététique personnalisé et une éducation diététique adaptée. Les diététiciens contribuent à la définition, à l'évaluation et au contrôle de la qualité de l'alimentation servie en collectivité, ainsi qu'aux **activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition**. »

Le titre de diététicien est **protégé** : seuls peuvent l'utiliser les titulaires du BTS Diététique et nutrition, du BUT Génie biologique parcours diététique et nutrition (ou des anciens diplômes équivalents) ou d'une autorisation d'exercice, **enregistrés au répertoire ADELI puis RPPS** (répertoire partagé des professionnels de santé). Le terme « nutritionniste », lui, n'est pas protégé : c'est pourquoi on emploie l'expression **diététicien- nutritionniste**.

Les missions en santé publique

Le référentiel du BTS (2024) cite, parmi les emplois accessibles, celui de **chargé de missions en santé publique** sur des programmes pilotés par des collectivités territoriales. Le guide de l'AFDN « Le diététicien dans les actions de santé publique » (version 2, 2022) décrit les missions suivantes :

- réaliser ou participer à un **diagnostic** de santé nutritionnelle d'un territoire ou d'une population ;
- **concevoir, coordonner, animer et évaluer** des projets et des actions de promotion de la santé, de prévention et d'éducation nutritionnelle ;
- concevoir des **outils pédagogiques** et des **supports de communication** adaptés (littératie) ;
- **former** des relais (animateurs, enseignants, aides à domicile, bénévoles d'associations) ;
- **conseiller** les décideurs (élus, directeurs de structures) sur la qualité de l'offre alimentaire (restauration scolaire, distributeurs, aide alimentaire) ;
- participer à des **études** et à la **recherche** (enquêteur, analyse de données) ;
- assurer une **veille** et diffuser des informations validées ;

- participer à des **réseaux** et à des instances (CLS, PAT, comités de pilotage).

Les cadres d'exercice

Employeur	Exemples de missions de santé publique
Collectivités territoriales (communes, CCAS, départements, régions)	Coordination d'un volet nutrition de CLS, PMI (1000 premiers jours), restauration scolaire, portage de repas, PAT
Centres sociaux, associations d'éducation populaire, épiceries solidaires	Ateliers cuisine, accompagnement de familles, éducation alimentaire
Associations de prévention, structures régionales Promotion Santé, réseaux	Conception de programmes, formation de relais, appui méthodologique
Mutuelles, Assurance maladie, entreprises (santé au travail)	Programmes de prévention pour les adhérents ou les salariés
Éducation nationale, enseignement supérieur	Interventions en classes, projets d'« écoles promotrices de santé », services de santé étudiante
Clubs et fédérations sportives	Nutrition du sportif, prévention des troubles du comportement alimentaire
Libéral	Interventions ponctuelles rémunérées par des structures (conventions de prestation)

La posture professionnelle en santé publique

- **Respecter** les personnes, leurs cultures, leurs choix et leurs contraintes ; ne pas juger ni culpabiliser (pas de « bons » et de « mauvais » aliments assénés de façon moralisatrice ; vocabulaire non stigmatisant).
- **Partir des besoins** et des représentations du public, et non de ce que le professionnel croit savoir.
- **Travailler en partenariat** et reconnaître les compétences des autres acteurs (animateurs, travailleurs sociaux, enseignants).
- **Transmettre des informations validées**, datées et sourcées, indépendantes des intérêts commerciaux ; déclarer et éviter les **conflits d'intérêts** (par exemple, ne pas faire la promotion d'une marque lors d'un atelier).
- **Respecter le secret professionnel** et le **RGPD** (données des participants, photos : droit à l'image).
- **S'auto-évaluer** et ajuster sa pratique (indicateur du référentiel).

Attention – Ce qu'un diététicien ne fait pas en santé publique

- Poser un **diagnostic médical** ou dépister une maladie sans cadre (le repérage se fait selon des protocoles et avec orientation vers un médecin).
- Prescrire un **régime thérapeutique** à un participant d'atelier : en cas de pathologie, on oriente vers une consultation (BC1).
- Utiliser des outils ou des messages d'une **marque** sans analyse critique (conflit d'intérêts).
- Diffuser des **photos** de participants sans autorisation écrite.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 1.3.8 – Le diététicien en santé publique et le projet

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois missions du diététicien en santé publique.
2. Donnez la définition d'un projet selon l'Afnor.
3. Distinguez projet, action et atelier avec un exemple.
4. Citez les quatre types de besoins de Bradshaw.
5. Citez trois choses qu'un diététicien ne fait pas en santé publique.
6. Citez les six étapes de la démarche de projet.

Corrigé – Point d'étape 1.3.8

1. Réaliser un diagnostic de santé nutritionnelle ; concevoir, animer et évaluer des projets et des actions ; concevoir des outils pédagogiques ; former des relais ; conseiller les décideurs sur l'offre alimentaire ; participer à des études ; assurer une veille ; participer à des réseaux (trois au choix).
2. « Processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant une date de début et une date de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conformément à des exigences spécifiques, incluant des contraintes de délais, de coûts et de ressources. »
3. Projet : « Bien manger, petit budget » sur six mois. Action : cycle de 4 ateliers culinaires (un objectif opérationnel). Atelier : la séance n° 3 « Repas complet petit budget ».
4. Normatif, ressenti, exprimé, comparatif.
5. Poser un diagnostic médical ; prescrire un régime thérapeutique à un participant d'atelier ; promouvoir une marque ; diffuser des photos sans autorisation écrite.
6. Analyse de situation et diagnostic ; priorités et objectifs ; conception et plan d'action ; mise en œuvre et pilotage ; évaluation ; valorisation.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

1.3.9 Fil rouge : le projet « Bien manger, petit budget, grand plaisir » du centre social des Tilleuls

Module · Référentiel : C3.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 1.2.2)

Ce cas, entièrement **fictif** mais construit à partir de situations réelles et d'ordres de grandeur nationaux, accompagne tout le BC3 (comme le cas de Mme L. dans le BC1). Il montre comment une étudiante de BTS, **Inès**, mène un projet de santé publique pendant son stage de six semaines, de l'analyse de situation à la valorisation, en remplissant les **14 fiches-outils** (F1 à F14). Les méthodes de chaque étape sont détaillées aux chapitres 7, 8 et 9 ; ici, l'objectif est de voir le **projet dans son ensemble** et de relier chaque étape aux notions du chapitre 1.

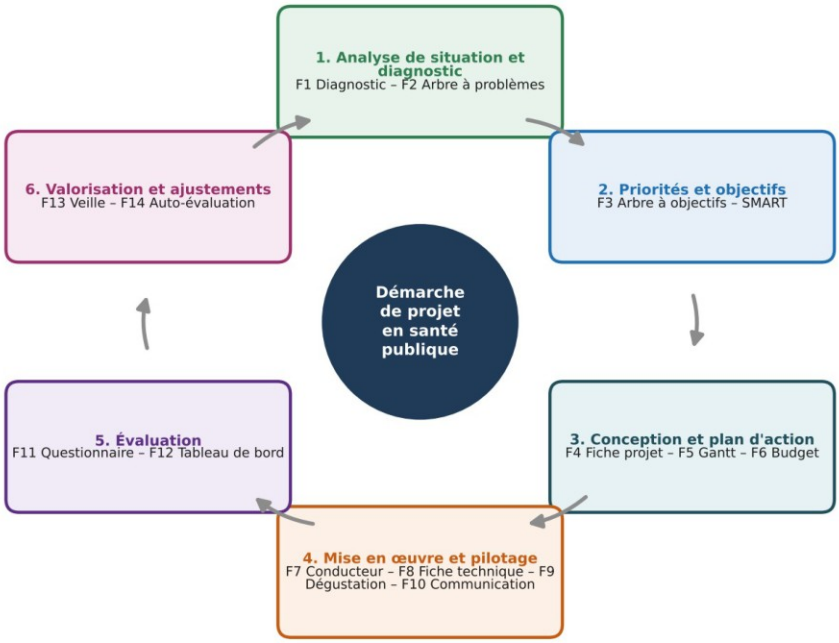


Figure 1.11 – La démarche de projet en santé publique et les fiches-outils F1 à F14

Comprendre le schéma – Figure 1.11

1. Analyse de situation et diagnostic : on rassemble les données sur le territoire et le public (F1) et on identifie le problème central, ses causes et ses conséquences (F2, arbre à problèmes).

2. Priorités et objectifs : on transforme l'arbre à problèmes en arbre à objectifs (F3) et on rédige des objectifs SMART.

3. Conception et plan d'action : on rédige la fiche projet (F4), le planning (F5, Gantt) et le budget (F6).

4. Mise en œuvre et pilotage : on prépare et anime chaque séance (F7 conducteur, F8 fiche technique d'atelier, F9 grille de dégustation) et on communique (F10).

5. Évaluation : on recueille et on analyse les données (F11 questionnaire, F12 tableau de bord).

6. Valorisation et ajustements : on diffuse les résultats, on assure la veille (F13) et on s'auto-évalue (F14).

7. Au centre, la démarche est un **cycle** : l'évaluation nourrit un nouveau diagnostic et l'amélioration du projet.

Le projet en santé publique : définitions et vocabulaire

Définition – Projet (Afnor)

Un projet est un « processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant une date de début et une date de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conformément à des exigences spécifiques, incluant des contraintes de délais, de coûts et de ressources » (définition reprise de la norme NF EN ISO 9000, citée par le CNED).

Un **projet de santé publique** ajoute trois caractéristiques à cette définition : il part d'un **diagnostic de situation** partagé, il vise une **population** (et non un individu) et il est **évalué** au regard de ses objectifs et de son effet sur les inégalités de santé. Il respecte le cadre légal : Code de la santé publique, recommandations officielles, code de déontologie, éthique et secret professionnel.

Notion	Définition	Exemple dans le fil rouge
Projet	Ensemble coordonné d'actions, sur une durée définie, qui répond à un problème identifié par un diagnostic, avec des objectifs, des moyens et une évaluation	« Bien manger, petit budget, grand plaisir » (septembre 2027 – mars 2028)
Action	Ensemble d'activités qui répond à **un objectif opérationnel** du projet	Cycle de 4 ateliers culinaires pour les parents ; exposition « goûters malins »
Atelier (ou séance)	Temps concret d'animation, avec un public, un lieu, une durée et un déroulé ; c'est une **modalité** d'une action	Atelier n° 3 « Repas complet petit budget » du 21 mars 2028
Appel à projets	Procédure par laquelle un financeur (ARS, Assurance maladie, collectivité, fondation) publie un **cahier des charges** (priorités, publics, critères, montant, date limite) et sélectionne les projets qu'il finance	Appel à projets « prévention – promotion de la santé » de l'ARS
Parties prenantes	Toutes les personnes et organisations concernées par le projet : l'**équipe** projet, les **partenaires** (appui humain, logistique, matériel ou financier, ponctuel ou régulier), les **usagers** (bénéficiaires)	Inès, Mme Martin et Mme Benali ; épicerie solidaire, PMI, CCAS ; parents du quartier
Valorisation	Faire connaître le projet et ses résultats aux participants, aux partenaires et aux financeurs, **tout au long** du projet	Article dans le journal municipal, bilan présenté au comité de pilotage
Capitalisation	Transformer l'expérience en **connaissances et en outils réutilisables** pour d'autres projets	Livret de recettes et fiche « comment monter un atelier » transmis au centre social

Erreur fréquente – Appeler « projet » un simple atelier

Un atelier culinaire isolé n'est pas un projet : il n'a ni diagnostic, ni objectifs hiérarchisés, ni évaluation d'ensemble. À l'oral, dites « l'atelier n° 3 est **une des actions** de mon projet », et non « mon projet, c'est un atelier ».

Méthode – Démarche d'étude et démarche de projet

La **démarche d'étude** analyse un sujet, une population ou un territoire à partir de données ; elle **produit de la connaissance** (chapitre 18). La **démarche de projet** utilise cette connaissance pour **agir**. L'étude recueille des données « **froides** » (statistiques, rapports d'activité, bilans) et des données « **chaudes** » (questionnaires, entretiens, observations, réunions). Le diagnostic d'un projet combine toujours les deux.

Outil d'analyse	À quoi il sert	Chapitre où il est approfondi
QQOQCP (Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?)	Décrire une situation de façon complète, sans oublier d'aspect	Chapitre 7
Arbre à problèmes et arbre à objectifs	Relier le problème central à ses causes et à ses conséquences, puis en déduire les objectifs	Chapitre 7 (exemples aux figures 1.12 et 1.13)
Diagramme d'Ishikawa (causes et effet)	Classer les causes d'un problème par familles (par exemple : personnes, offre alimentaire, environnement, organisation, budget)	Chapitre 7

Outil d'analyse	À quoi il sert	Chapitre où il est approfondi
Analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces)	Évaluer la faisabilité d'un projet : ressources internes et contexte externe	Chapitre 7
Analyse des champs de forces (Lewin)	Identifier les forces favorables et les forces de résistance à un changement	Chapitre 8
Carte mentale	Organiser les idées d'un sujet autour d'un thème central, en équipe ou seul	Chapitres 7 et 15

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le contexte

Valmont est une commune fictive de 38 000 habitants. Le **quartier des Tilleuls** (4 200 habitants) est un **quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)**. Le **centre social des Tilleuls**, agréé par la CAF (« animation collective familles »), dispose d'une **cuisine pédagogique**. Sa référente familles, **Mme Martin** (conseillère en économie sociale et familiale), est la **tutrice** d'Inès. Une diététicienne, **Mme Benali**, intervient au centre social dans le cadre d'une convention avec le CCAS. L'**épicerie solidaire** « Le Panier partagé » (CCAS) est située à 300 mètres. **Calendrier du stage** : période 1 du 31 mai au 11 juin 2027 (2 semaines, fin de 1re année) ; travail de conception en établissement de septembre 2027 à février 2028 ; période 2 du 6 au 31 mars 2028 (4 semaines, 2e année), soit **6 semaines au total** comme le prévoit le référentiel ; épreuve E5 en juin 2028.

Les besoins : la typologie de Bradshaw

Le mot « besoin » est au cœur du diagnostic. Le sociologue britannique **Jonathan Bradshaw** a distingué en **1972** quatre types de besoins sociaux. Cette typologie est classique en santé publique : elle oblige à croiser le regard des professionnels et celui de la population.

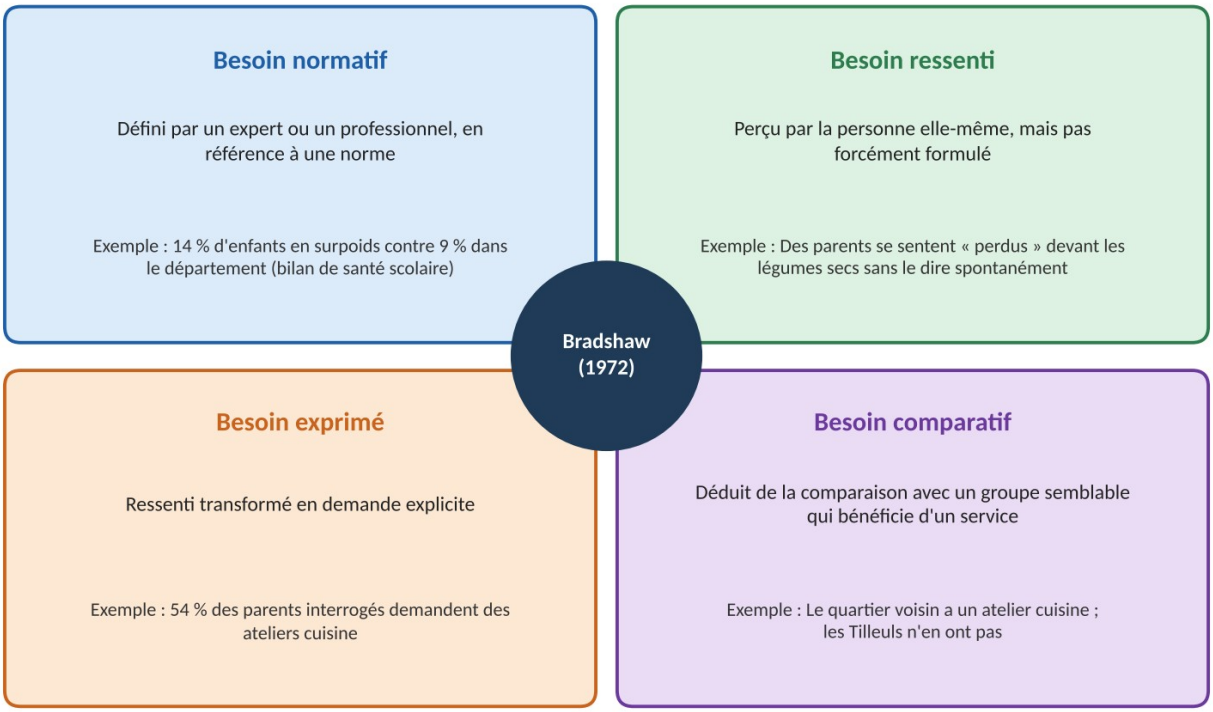


Figure 1.11 bis – Les quatre types de besoins selon Bradshaw (1972), illustrés par le fil rouge

Comprendre le schéma – Figure 1.11 bis

1. **En bleu, le besoin normatif** : un expert le définit en comparant une situation à une **norme** (recommandation, moyenne départementale, repère du PNNS).

2. **En vert, le besoin ressenti** : c'est la population qui le **perçoit**, même si elle ne le dit pas spontanément ; on le fait émerger par des entretiens ou des groupes de parole.
3. **En orange, le besoin exprimé** : c'est un besoin ressenti devenu **demande** (inscriptions, réponses à un questionnaire, demandes au guichet).
4. **En violet, le besoin comparatif** : on le déduit en comparant avec un groupe semblable qui bénéficie déjà d'un service.
5. Un besoin est d'autant plus **prioritaire** qu'il apparaît dans plusieurs cases à la fois.

Erreur fréquente – Attribuer les besoins ressentis aux professionnels

Les besoins **ressentis** sont ceux de la **population**. Ce que constatent ou estiment les professionnels (animatrice, infirmière, PMI) relève du besoin **normatif**, ou de l'**observation**. Écrire « besoins ressentis par les professionnels » est une erreur relevée par les jurys.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.5 bis – Classer des besoins

Pour un projet dans une résidence autonomie (78 résidents), classez chaque information selon Bradshaw.

a) Le médecin coordonnateur note que 17 résidents ont perdu plus de 5 % de leur poids en un mois.

b) Au conseil de la vie sociale, 12 résidents demandent des repas plus variés le soir.

c) Lors d'un entretien, une résidente confie qu'elle « n'a plus envie de cuisiner pour elle seule ».

d) La résidence voisine propose un repas partagé hebdomadaire ; celle-ci non.

Calculez la part de résidents concernés en a) et en b).

Corrigé – Exercice 1.5 bis

a) **Normatif** : la norme est le critère de dénutrition (perte de poids d'au moins 5 % en un mois, HAS 2021). Part : 17 / 78 × 100 = **21,8 %**.

b) **Exprimé** : demande formulée dans une instance. Part : 12 / 78 × 100 = **15,4 %**.

c) **Ressenti** : la résidente perçoit une difficulté sans en faire une demande.

d) **Comparatif** : comparaison avec une structure semblable.

Conclusion : la dénutrition et la convivialité des repas apparaissent dans plusieurs types de besoins ; ce sont des priorités solides pour le projet.

Étape 1 – Analyse de situation et diagnostic (fiche F1)

Pendant la période 1, Inès rassemble plusieurs types de données : les **données objectives** (statistiques du territoire), les **besoins exprimés** par les habitants (leurs demandes), les **besoins ressentis** qu'elle fait émerger dans un groupe de parole, et les **besoins normatifs** repérés par les professionnels au regard des normes (typologie de Bradshaw), auxquels s'ajoutent les **besoins observés** (ce qu'elle constate elle-même).

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F1 – Diagnostic de situation (extrait rempli)

Rubrique	Données recueillies	Source
Territoire	Valmont, 38 000 habitants ; QPV des Tilleuls : 4 200 habitants ; 32 % de moins de 18 ans (21 % dans la commune)	Insee, recensement ; sig.ville.gouv.fr (données fictives)

Rubrique	Données recueillies	Source
Situation sociale	Taux de pauvreté 41 % (15 % dans la commune) ; 28 % de familles monoparentales ; taux de chômage 24 %	Insee, Filosofi ; contrat de ville (données fictives)
Santé	14 % d'enfants en surpoids (obésité comprise) lors du bilan de grande section dans les 2 écoles du quartier (9 % en moyenne dans le département)	Service de santé scolaire, bilan 2026 (fictif)
Offre alimentaire	1 supérette, 3 restaurants rapides, 1 boulangerie ; marché le samedi en centre-ville (2,5 km, bus toutes les 30 min)	Observation, repérage à pied
Ressources	Centre social avec cuisine pédagogique ; épicerie solidaire (85 familles inscrites) ; jardin partagé (8 parcelles) ; PMI ; maison de santé ; 2 écoles élémentaires	Entretiens, sites internet
Politiques	PNNS 5 (2026-2030) ; PRS de la région (priorité : nutrition des enfants en QPV) ; CLS de Valmont 2024- 2028, fiche-action « Bien manger dans les quartiers » ; PAT de l'agglomération	Sites ARS, ministère, agglomération
Besoins exprimés (habitants)	Questionnaire à 48 parents (sortie d'école) + groupe de parole de 8 parents : 71 % (34/48) pensent que « manger équilibré coûte cher » ; 58 % (28/48) « ne savent pas cuisiner les légumes secs » ; 63 % (30/48) disent que leurs enfants refusent les légumes ; 54 % (26/48) souhaitent des ateliers cuisine	Enquête d'Inès, juin 2027
Besoins normatifs (repérés par les professionnels)	Animatrice : goûters industriels et sodas fréquents ; épicerie : les légumes secs et les légumes frais restent en rayon ; PMI : allaitement court, diversification précoce	Entretiens semi-directifs (3)
Besoins observés	27 % (13/48) des familles consomment des légumes secs au moins 2 fois par semaine ; 46 % (22/48) déclarent que leurs enfants boivent une boisson sucrée tous les jours	Questionnaire, observation des goûters

À vous de jouer – Exercice d'application 1.6 – Calculer et interpréter des pourcentages du diagnostic

Vérifiez les pourcentages de la fiche F1 (arrondis à l'unité) et calculez combien de familles inscrites à l'épicerie solidaire (85) on peut estimer intéressées par des ateliers cuisine si la proportion observée chez les 48 parents s'applique.

Corrigé

Formule : pourcentage = effectif / effectif total × 100.

- 34 / 48 × 100 = 70,8 % ≈ **71 %** ; 28 / 48 × 100 = 58,3 % ≈ **58 %** ; 30 / 48 × 100 = 62,5 % ≈ **63 %** ; 26 / 48 × 100 = 54,2 % ≈ **54 %** ; 13 / 48 × 100 = 27,1 % ≈ **27 %** ; 22 / 48 × 100 = 45,8 % ≈ **46 %**.
- **Estimation** : 85 × 0,542 = 46,1, soit environ **46 familles** potentiellement intéressées.
- **Interprétation et limite** : cette extrapolation suppose que les parents interrogés à la sortie de l'école ressemblent aux familles de l'épicerie, ce qui n'est pas certain (**biais de sélection**, chapitre 16) ; il s'agit d'un ordre de grandeur pour dimensionner l'action (un cycle de 12 familles est réaliste, avec une liste d'attente).

Étape 2 – Problème central, causes et conséquences (fiche F2)

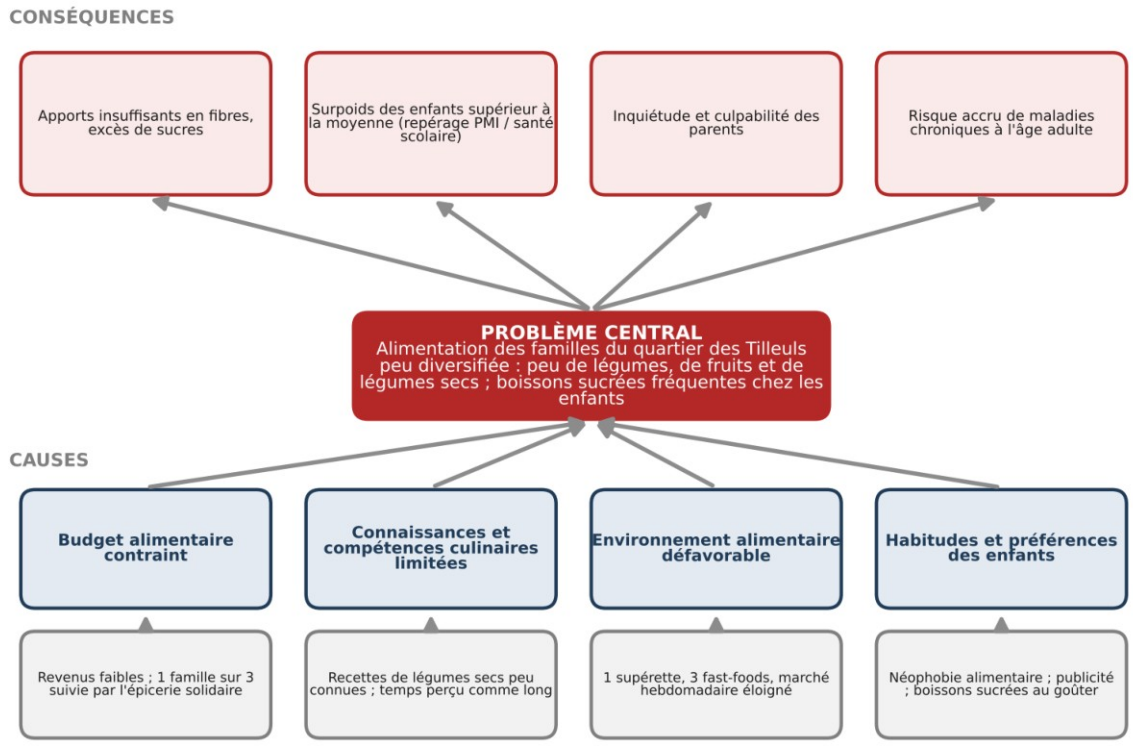


Figure 1.12 – Arbre à problèmes du projet fil rouge (fiche F2)

Comprendre le schéma – Figure 1.12

1. Au centre, le **problème central**, formulé comme une situation négative observable : une alimentation des familles peu diversifiée (peu de légumes, de fruits et de légumes secs, boissons sucrées fréquentes chez les enfants).
2. En bas, les **causes** (racines) : budget contraint, connaissances et compétences culinaires limitées, environnement alimentaire défavorable, habitudes et préférences des enfants ; chaque cause est précisée par un fait issu du diagnostic (encadrés gris).
3. En haut, les **conséquences** (branches) : apports insuffisants en fibres et excès de sucres, surpoids des enfants supérieur à la moyenne, inquiétude des parents, risque de maladies chroniques.
4. Les flèches indiquent la **relation de cause à effet**. L'arbre permet de choisir **sur quelles causes agir** : le centre social peut agir sur les compétences, les habitudes et en partie sur l'accès (partenariat avec l'épicerie), mais pas directement sur les revenus (il peut en revanche **plaider** auprès de la commune).

Étape 3 – Priorités et objectifs (fiche F3)

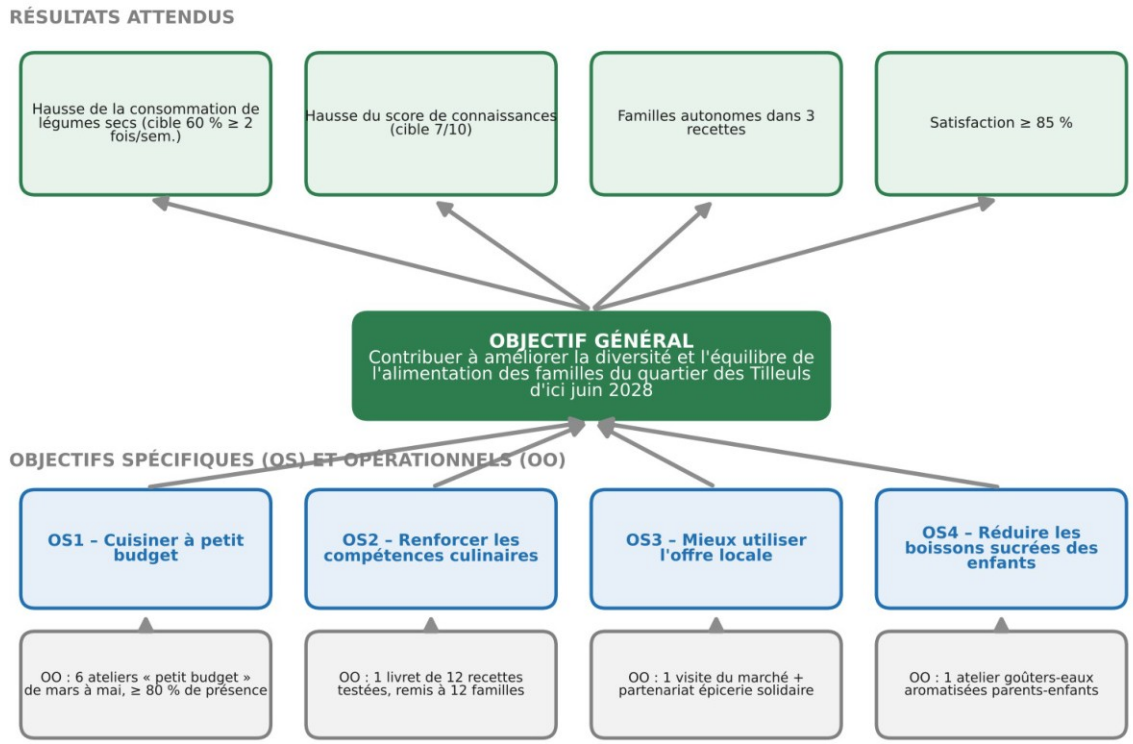


Figure 1.13 – Arbre à objectifs du projet fil rouge (fiche F3)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F3 – Objectifs SMART (extrait rempli)

Niveau	Formulation	Indicateur
Objectif général	Contribuer à améliorer la diversité et l'équilibre de l'alimentation des familles du quartier des Tilleuls d'ici juin 2028	(à long terme, non mesuré par le seul projet)
Objectif spécifique 1	D'ici fin mai 2028, au moins 60 % des familles participantes déclarent consommer des légumes secs au moins 2 fois par semaine (contre 25 % au début du cycle)	% de familles (questionnaire avant/après)
Objectif spécifique 2	À la fin du cycle, le score moyen de connaissances des participants sur l'alimentation à petit budget atteint au moins 7/10	Score moyen au questionnaire
Objectif spécifique 3	D'ici fin mai 2028, les familles participantes savent repérer et utiliser l'offre locale à petit prix (marché, épicerie solidaire)	Participation à la visite ; achats déclarés
Objectif spécifique 4	D'ici fin mai 2028, les familles participantes proposent moins souvent une boisson sucrée au goûter	Fréquence déclarée
Objectif opérationnel	Animer 6 ateliers culinaires de 3 heures, de mars à mai 2028, pour 12 familles, avec un taux de présence d'au moins 80 %	Nombre d'ateliers ; présences / 72

Niveau	Formulation	Indicateur
Objectif opérationnel	Réaliser un livret de 12 recettes testées pendant les ateliers et le remettre aux 12 familles le 27 mai 2028	Livret réalisé et distribué

Méthode pas à pas – Vérifier qu'un objectif est SMART

Spécifique (un seul résultat, un public précis) – **M**esurable (indicateur chiffré) – **A**tteignable (réaliste au regard des moyens) – **R**éaliste / pertinent (répond au problème identifié) – **T**emporel (échéance). Exemple de vérification pour l'objectif spécifique 1 : S = consommer des légumes secs, familles participantes ; M = au moins 60 % ; A = passer de 25 % à 60 % en 3 mois est ambitieux mais possible car 3 ateliers sur 6 portent sur les légumes secs ; R = répond à la cause « compétences culinaires » et au constat de l'épicerie ; T = fin mai 2028. La méthode complète est au chapitre 7.

Étape 4 – Conception : fiche projet, planning et budget (fiches F4, F5, F6)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F4 – Fiche projet / réponse à l'appel à projets de l'ARS (extrait rempli)

Rubrique	Contenu
Intitulé	« Bien manger, petit budget, grand plaisir »
Porteur	Centre social des Tilleuls (association loi 1901), référente : Mme Martin ; conception et animation : Inès (étudiante en BTS Diététique et nutrition) avec l'appui de Mme Benali, diététicienne
Partenaires	Épicerie solidaire « Le Panier partagé » (CCAS) : orientation des familles, produits utilisés ; écoles élémentaires (diffusion) ; PMI (orientation) ; marché de Valmont (visite) ; jardin partagé
Public	12 familles du QPV (parents et, pour l'atelier 4, enfants de 6 à 11 ans)
Inscription dans les politiques	PNNS 5 axe 2 ; PRS (nutrition des enfants en QPV) ; CLS de Valmont, fiche-action 3 ; PAT de l'agglomération
Type d'intervention	Éducation pour la santé (alimentaire, nutritionnelle, sensorielle) au service de la prévention primaire sélective ; démarche de promotion de la santé (participation des familles au choix des recettes, partenariat avec l'épicerie)
Actions	6 ateliers culinaires (mardi 9 h – 12 h) : 1) légumes secs ; 2) légumes de saison ; 3) repas complet petit budget ; 4) goûters et boissons (parents-enfants) ; 5) anti-gaspillage ; 6) recettes du monde choisies par les familles ; visite du marché ; temps fort festif avec remise du livret
Calendrier	7 mars – 27 mai 2028
Évaluation	Processus (présences, ateliers réalisés, budget) et résultats (questionnaire avant/après, consommation déclarée de légumes secs, satisfaction) – fiche F12
Budget	3 510 € (dont 450 € de contributions en nature) ; demande à l'ARS : 1 500 €

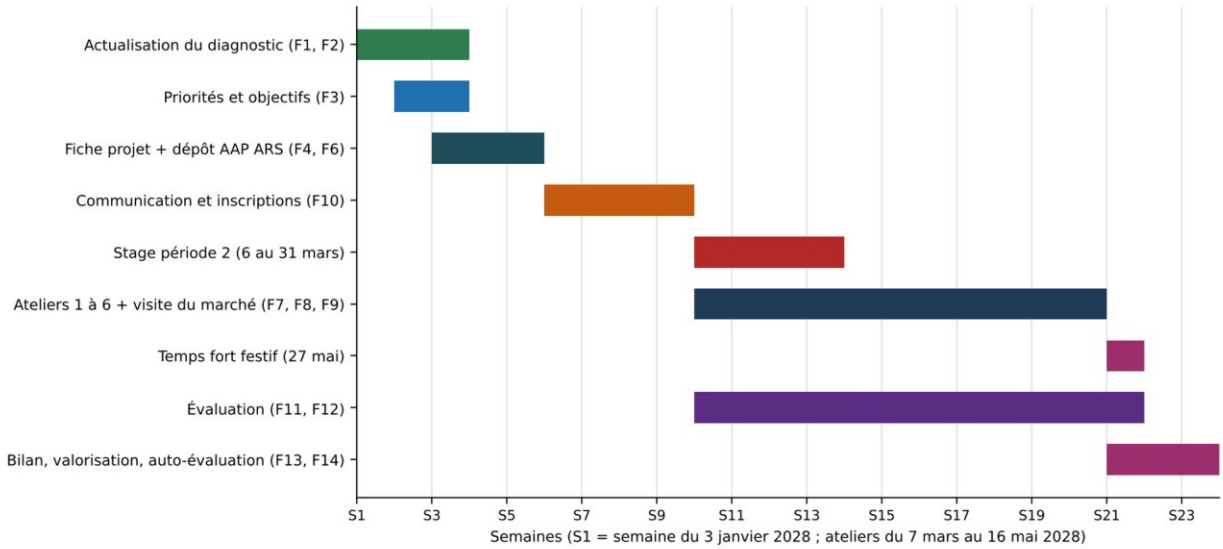


Figure 1.14 – Diagramme de Gantt du projet fil rouge (fiche F5)

Comprendre le schéma – Figure 1.14

1. Chaque barre représente une **tâche**, positionnée selon sa semaine de début et sa durée (S1 = semaine du 3 janvier 2028).
2. Les tâches de conception (diagnostic actualisé, objectifs, fiche projet et dépôt de l'appel à projets) se chevauchent en janvier et février.
3. La barre rouge montre la **période 2 du stage** (6 au 31 mars) : Inès y anime les ateliers 1 à 3 et la visite du marché ; la diététicienne et la référente familles animent les ateliers 4 à 6 en suivant les conducteurs qu'elle a rédigés, et lui transmettent les données d'évaluation.
4. L'**évaluation** court pendant tout le cycle (questionnaire avant au 1er atelier, émargements à chaque séance, questionnaire après au 6e atelier).
5. Le **temps fort festif** (27 mai) et le bilan clôturent le projet.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F5 – Feuille de temps d'Inès, période 2 (extrait)

Activité	Heures	Commentaire
Préparation des ateliers 1 à 6 (conducteurs, fiches techniques, courses)	38	Dont 6 h pour les ateliers 4 à 6 animés par l'équipe
Animation des ateliers 1 à 3 (3 × 3 h)	9	Avec la diététicienne
Visite du marché (samedi 25 mars)	4	Récupération du samedi
Communication (affiches, flyers, messages aux familles)	12	Supports validés par la tutrice
Évaluation (questionnaires, saisie, tableur)	16	Dépouillement complet à réception des questionnaires « après »
Livret de recettes	18	Maquette, relecture FALC
Réunions (tutrice, comité de pilotage, partenaires)	10	Dont 1 comité de pilotage
Rédaction du dossier et auto-évaluation	23	
Total	130	Pour 4 semaines de 35 h, soit 140 h : 10 h de temps d'observation d'autres activités du centre social

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F6 – Budget prévisionnel (calculé dans le tableur, feuille 3)

Charges	Quantité	Coût unitaire	Montant
60 – Denrées alimentaires (6 ateliers + temps fort)	7	30,00 €	210,00 €
60 – Petit matériel de cuisine (balance, ustensiles)	1	180,00 €	180,00 €
60 – Matériel et supports pédagogiques	1	150,00 €	150,00 €
62 – Impression et communication (affiches, flyers, livret)	1	220,00 €	220,00 €
62 – Déplacements (visite du marché)	1	60,00 €	60,00 €
64 – Diététicienne (heures)	40	38,00 €	1 520,00 €
64 – Coordinatrice / animatrice familles (heures)	30	24,00 €	720,00 €
86 – Mise à disposition de locaux (valorisation)	7	30,00 €	210,00 €
86 – Bénévolat (valorisation, heures)	20	12,00 €	240,00 €
Total des charges			3 510,00 €

Produits	Montant
74 – Subvention ARS (appel à projets prévention)	1 500,00 €
74 – Commune / CCAS (contrat de ville)	600,00 €
74 – CAF (animation collective familles)	400,00 €
75 – Participation des familles (2 € × 12 familles × 6 ateliers)	144,00 €
Autofinancement du centre social	416,00 €
87 – Contributions volontaires en nature	450,00 €
Total des produits	3 510,00 €

Corrigé – Les calculs du budget, pas à pas

Étape 1 – Charges : chaque ligne = quantité × coût unitaire ; par exemple, diététicienne : 40 h × 38 € = 1 520 €. Somme : 210 + 180 + 150 + 220 + 60 + 1 520 + 720 + 210 + 240 = **3 510 €**. **Étape 2 – Participation des familles** : 2 € × 12 familles × 6 ateliers = **144 €**. **Étape 3 – Contributions en nature** (comptes 86 et 87, qui doivent être égaux) : 210 + 240 = **450 €**. **Étape 4 – Autofinancement** (montant qui équilibre le budget) : 3 510 − (1 500 + 600 + 400 + 144 + 450) = 3 510 − 3 094 = **416 €**. **Étape 5 – Indicateurs** : part de la subvention ARS dans les produits = 1 500 / 3 510 = 0,427, soit **42,7 %** ; part des financements publics (ARS + commune + CAF) = 2 500 / 3 510 = **71,2 %** ; coût par famille = 3 510 / 12 = **292,50 €** ; part du personnel = (1 520 + 720) / 3 510 = **63,8 %**. **Interprétation** : un budget prévisionnel doit être **équilibré** (total des charges = total des produits) ; un financeur ne finance jamais 100 % d'un projet, d'où la diversité des financeurs ; le poste principal est le **temps humain**, ce qui est habituel en éducation pour la santé.

Étape 5 – Mise en œuvre : l'atelier n° 3 « Repas complet petit budget » (fiches F7, F8, F9)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F7 – Conducteur de séance, atelier n° 3 (mardi 28 mars 2028, 9 h – 12 h)

Horaire	Étape et objectif	Contenu et déroulement	Méthode, outils	Qui
8 h 30 – 9 h	Installation	Plan de travail, ingrédients pesés par recette, affichage des fiches recettes, tenues, désinfection des surfaces	Fiche technique F8	Inès, Mme Benali

Horaire	Étape et objectif	Contenu et déroulement	Méthode, outils	Qui
9 h – 9 h 15	Accueil, émargement	Café, émargement, rappel des règles (hygiène, tablier, cheveux attachés, lavage des mains), présentation du menu	Tour de table « une couleur pour votre humeur »	Inès
9 h 15 – 9 h 35	Représentations	« Pour vous, un repas équilibré à petit prix, c'est… » ; classement de 10 cartes- aliments par prix au kilo puis par prix par portion	Photo-expression, cartes-aliments	Inès
9 h 35 – 11 h 05	Réalisation culinaire	3 groupes de 3-4 personnes : salade de chou-carottes ; parmentier de lentilles corail ; crumble pommes-avoine ; consignes de sécurité (couteaux, four) ; tri des déchets	Fiches recettes illustrées (pictogrammes)	Inès + Mme Benali (1 animatrice pour 2 groupes)
11 h 05 – 11 h 35	Dégustation et analyse sensorielle	Repas partagé ; grille de dégustation (échelle de 1 à 5) ; échanges sur les goûts des enfants	Grille F9	Inès
11 h 35 – 11 h 50	Synthèse	Calcul collectif du coût par personne (1,38 €) ; 3 astuces à retenir ; recette à refaire à la maison	Tableau papier	Inès
11 h 50 – 12 h	Évaluation et clôture	Évaluation « météo » (soleil, nuage, pluie) + 1 mot ; distribution des fiches recettes ; restes partagés dans des boîtes apportées par les familles	Émargement, boîtes	Mme Benali
12 h – 12 h 30	Rangement, bilan à chaud	Vaisselle, nettoyage, tri ; bilan entre animatrices (ce qui a marché, ce qui est à améliorer)	Fiche bilan	Toutes

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F8 – Fiche technique de l'atelier : mise à l'échelle et coût (calculés dans

le tableur, feuille 1) Recettes de base pour 4 portions, préparées pour **12 portions** (10 participants + 2 animatrices). **Coefficient** = portions visées / portions de base = 12 / 4 = **3**.

Ingrédient	Base (4 p.)	Pour 12 p.	Prix	Coût	Qualité
Salade chou-carottes					
Chou blanc	200 g	600 g	1,60 €/kg	0,96 €	saison, local
Carottes	150 g	450 g	1,40 €/kg	0,63 €	saison, local
Huile de colza	15 g	45 g	3,50 €/L	0,16 €	
Vinaigre de cidre	10 g	30 g	2,00 €/L	0,06 €	
Moutarde	5 g	15 g	4,00 €/kg	0,06 €	allergène
Parmentier de lentilles					

Ingrédient	Base (4 p.)	Pour 12 p.	Prix	Coût	Qualité
Lentilles corail sèches	160 g	480 g	3,20 €/kg	1,54 €	
Carottes	300 g	900 g	1,40 €/kg	1,26 €	saison, local
Oignon	100 g	300 g	1,80 €/kg	0,54 €	saison, local
Pommes de terre	600 g	1 800 g	1,30 €/kg	2,34 €	saison, local
Lait demi-écrémé	150 mL	450 mL	1,05 €/L	0,47 €	allergène (lait)
Huile de colza	20 g	60 g	3,50 €/L	0,21 €	
Emmental râpé	40 g	120 g	9,90 €/kg	1,19 €	allergène (lait)
Concentré de tomate	30 g	90 g	4,00 €/kg	0,36 €	
Épices (cumin, paprika)	4 g	12 g	25,00 €/kg	0,30 €	
Crumble pommes-avoine					
Pommes	500 g	1 500 g	2,90 €/kg	4,35 €	saison, local, bio
Flocons d'avoine	60 g	180 g	2,50 €/kg	0,45 €	allergène (gluten)
Farine de blé T65	40 g	120 g	1,60 €/kg	0,19 €	Label Rouge ; gluten
Beurre doux	40 g	120 g	10,00 €/kg	1,20 €	allergène (lait)
Sucre roux	30 g	90 g	1,20 €/kg	0,11 €	
Cannelle	2 g	6 g	30,00 €/kg	0,18 €	

Corrigé – Les calculs de la fiche technique, pas à pas

Étape 1 – Quantité à prévoir = quantité de base × coefficient. Exemple : lentilles corail : 160 g × 3 = **480 g**. **Étape 2 – Coût d'un ingrédient** = quantité (g) / 1 000 × prix (€/kg). Exemple : 480 / 1 000 × 3,20 = **1,536 €** ≈ 1,54 €. **Étape 3 – Coût de chaque recette** (somme des ingrédients, valeurs non arrondies) : salade = 0,96 + 0,63 + 0,1575 + 0,06 + 0,06 = **1,87 €** ; parmentier = 1,536 + 1,26 + 0,54 + 2,34 + 0,4725 + 0,21 + 1,188 + 0,36 + 0,30 = **8,21** € ; crumble = 4,35 + 0,45 + 0,192 + 1,20 + 0,108 + 0,18 = **6,48 €**. **Étape 4 – Coût par portion** = coût de la recette / 12 : salade 1,8675 / 12 = **0,16 €** ; parmentier 8,2065 / 12 = **0,68** € ; crumble 6,48 / 12 = **0,54 €**. **Étape 5 – Coût du repas complet** : 1,8675 + 8,2065 + 6,48 = **16,55 €** pour 12 personnes, soit 16,554 / 12 = **1,38 € par personne**. **Étape 6 – Part des produits de qualité (en valeur)** : produits de saison = 0,96 + 0,63 + 1,26 + 0,54 + 2,34 + 4,35 = 10,08 € ; 10,08 / 16,554 = **60,9 %** (les mêmes produits sont locaux : 60,9 %) ; bio = 4,35 / 16,554 = **26,3 %** ; produits « durables et de qualité » au sens EGalim (bio ou Label Rouge) = (4,35 + 0,192) / 16,554 = **27,4 %**. **Interprétation** : un repas complet, fait maison, coûte **1,38 € par personne en denrées**, ce qui répond directement à la représentation « manger équilibré coûte cher » ; les pommes bio représentent à elles seules 26 % du coût : le choix du bio est possible sur un produit de saison. Si on utilisait le repère EGalim de la restauration collective (50 %), il manquerait 22,6 points : ce repère n'est pas obligatoire pour un atelier, mais il sert de **point de comparaison** pédagogique.

Lien diététique – Lien BPADN : la valeur nutritionnelle d'une portion de parmentier

Une portion contient 40 g de lentilles corail crues, 150 g de pommes de terre, 75 g de carottes, 37,5 mL de lait et 10 g d'emmental. Avec les teneurs en protéines de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025) : lentille corail sèche 27,7 g/100 g ; pomme de terre crue sans peau 2,02 g ; carotte crue 0,78 g ; lait demi-écrémé UHT 3,48 g ; emmental râpé 27,6 g. Calcul : 40 × 27,7 / 100 = 11,08 g ; 150 × 2,02 / 100 = 3,03 g ; 75 × 0,78 / 100 = 0,59 g ; 37,5 × 3,48 / 100 = 1,31 g ; 10 × 27,6 / 100 = 2,76 g ; **total ≈ 18,8 g de protéines**, dont (11,08 + 3,03 + 0,59) / 18,77 = 78,3 % d'origine végétale. L'association **légumineuse + produit laitier + féculent** améliore la complémentarité des acides aminés (lysine des légumineuses, acides aminés soufrés des céréales et du lait) : c'est un plat complet adapté au repère « légumes secs au moins 2 fois par semaine ».

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F8 (suite) – Hygiène, sécurité, éco-gestes et allergènes

- **Hygiène** : lavage des mains à l'arrivée et entre chaque manipulation ; tablier, cheveux attachés ; légumes lavés ; lentilles rincées ; plat cuit servi immédiatement (ou maintenu au-dessus de 63 °C) ; restes refroidis rapidement et conservés au froid (0 à 4 °C) dans des boîtes fermées, à consommer sous 24 heures ; un plat témoin n'est pas obligatoire en atelier familial mais on note les lots des produits utilisés.
- **Sécurité** : couteaux posés à plat, planche stabilisée par un torchon humide, poignées de casseroles tournées vers l'intérieur, gants de cuisine pour le four ; enfants (atelier 4) jamais seuls près des plaques.
- **Éco-gestes** : légumes de saison et locaux ; épluchures de carottes et de pommes compostées au jardin partagé ; eau de cuisson des lentilles réutilisée pour la purée ; four rempli (crumble et parmentier cuits ensemble) ; produits en vrac (lentilles, flocons) ; restes emportés dans des boîtes réutilisables ; pas de vaisselle jetable.
- **Allergènes à déclarer** (14 allergènes du règlement INCO n° 1169/2011) : **lait** (lait, emmental, beurre), **gluten** (farine de blé, flocons d'avoine), **moutarde** ; **sulfites** possibles dans le vinaigre (vérifier l'étiquette). Recueil des allergies à l'inscription (fiche participant) ; variante sans lait (huile d'olive et lait végétal enrichi) prévue.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F9 – Grille de dégustation : résultats de l'atelier n° 3 (10 participants)

Échelle hédonique de 1 (« je n'aime pas du tout ») à 5 (« j'aime beaucoup »).

Préparation	Notes des 10 participants	Moyenne
Salade chou-carottes	3 – 4 – 3 – 4 – 2 – 3 – 4 – 3 – 4 – 3	3,3
Parmentier de lentilles	5 – 4 – 4 – 5 – 3 – 4 – 5 – 4 – 4 – 5	4,3
Crumble pommes-avoine	5 – 5 – 4 – 5 – 5 – 4 – 5 – 5 – 4 – 5	4,7

Calcul : moyenne = somme des notes / nombre de notes. Salade : (3 + 4 + 3 + 4 + 2 + 3 + 4 + 3 + 4 + 3) / 10 = 33 / 10 = **3,3** ; parmentier : 43 / 10 = **4,3** ; crumble : 47 / 10 = **4,7**. **Interprétation** : le plat à base de légumes secs est très bien accepté (4,3/5), ce qui est encourageant pour l'objectif spécifique 1 ; la salade de chou est moins appréciée (« trop acide », « chou trop dur ») : ajustement décidé pour le livret : chou émincé très finement et mariné 15 minutes, ajout de pomme râpée et de raisins secs.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F10 – Plan de communication (extrait)

Objectif	Cible	Message	Support et canal	Calendrier
Faire connaître et recruter	Familles du quartier	« Cuisinez bon et pas cher, venez avec nous ! »	Affiches A3 (écoles, épicerie, PMI, centre social) ; flyers illustrés traduits en arabe et en turc ; message sur le groupe de messagerie des parents du centre social	Février 2028
Mobiliser les partenaires	Épicerie, écoles, PMI	Présentation du projet et du rôle de chacun	Mail + réunion de présentation (diaporama de 8 diapositives)	Janvier 2028
Informer les financeurs	ARS, commune, CAF	Avancement et résultats	Fiche projet, bilan intermédiaire, bilan final	Février, avril, juin 2028
Valoriser	Habitants, élus, professionnels	« 12 familles, 12 recettes à moins de 1,50 € par personne »	Livret de recettes (FALC, pictogrammes), article dans le journal municipal, poster au forum santé	Mai-juin 2028

Points de vigilance : littératie (phrases courtes, pictogrammes, police lisible ≥ 12 pt, chapitre 5) ; **précarité numérique** (ne pas compter uniquement sur le numérique) ; **droit à l'image** et **RGPD** (autorisation écrite pour toute photo, pas de nom de famille dans le livret, données d'inscription conservées au centre social et détruites à la fin du projet).

Étape 6 – Évaluation (fiches F11 et F12)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F11 – Questionnaire d'évaluation et dépouillement (calculés dans le

tableur, feuille 5) Le même questionnaire de 10 questions de connaissances (une réponse juste = 1 point) a été rempli au 1er atelier (« avant ») et au 6e atelier (« après ») par les **12** participants, identifiés par un **code anonyme** (P01 à P12). Exemples de questions : « Combien de fois par semaine est-il conseillé de manger des légumes secs ? » ; « Quel est le prix au kilo des lentilles par rapport à celui de la viande hachée ? » ; « Citez deux légumes de saison en mars ».

Statistique	Score avant (/10)	Score après (/10)	Progression
Effectif	12	12	12
Moyenne	4,75	7,17	+ 2,42
Médiane	5	7	2
Écart-type	1,22	0,94	0,51
Minimum – maximum	3 – 7	6 – 9	2 – 3

Corrigé – Le dépouillement, pas à pas

Scores avant : 4, 5, 3, 6, 5, 4, 7, 5, 3, 6, 4, 5. Scores après : 7, 8, 6, 8, 7, 6, 9, 7, 6, 8, 7, 7. **Étape 1 – Moyenne** = somme / effectif. Avant : 57 / 12 = **4,75** ; après : 86 / 12 = **7,17** ; progression moyenne : 7,17 − 4,75 = **+ 2,42 points**. **Étape 2 – Médiane** (valeur qui partage la série ordonnée en deux moitiés ; avec 12 valeurs, moyenne de la 6e et de la 7e). Avant, série ordonnée : 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7 → (5 + 5) / 2 = **5**. Après : 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9 → (7 + 7) / 2 = **7**. **Étape 3 – Écart-type** (dispersion autour de la moyenne ; formule de l'échantillon : $s = \sqrt{[\ (x - \text{moyenne})^2 / \Sigma\ (n - 1)]}$). Avant : $(x - 4{,}75)^2 = 16{,}25$; 16,25 / 11 = 1,477 ; √1,477 = **1,22**. Après : $(x - 7{,}17)^2 = 9{,}67$; 9,67 / 11 = Σ Σ 0,879 ; √0,879 = **0,94**. **Étape 4 – Proportions** : participants ayant progressé = 12 / 12 = **100 %** ; score après ≥ 7 = 9 / 12 = **75 %** ; légumes secs au moins 2 fois par semaine : avant 3 / 12 = **25 %**, après 9 / 12 = **75 %**, soit **+ 50 points** ; satisfaits ou très satisfaits = (7 + 4) / 12 = **91,7 %** ; note moyenne de satisfaction = 42 / 12 = **3,50 / 4**. **Interprétation** : les connaissances progressent pour tous les participants et deviennent plus homogènes (l'écart-type diminue de 1,22 à 0,94) ; l'objectif « score moyen ≥ 7/10 » est atteint (7,17). Limites : petit effectif, données **déclaratives**, pas de groupe témoin, mesure à court terme : on ne peut pas conclure à un changement durable des comportements (chapitre 9).

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F12 – Tableau de bord d'évaluation (calculé dans le tableur, feuille 6)

Type	Indicateur	Prévu	Réalisé	Taux d'atteinte	Statut
Processus	Ateliers réalisés	6	6	100 %	Atteint
Processus	Familles inscrites	12	12	100 %	Atteint
Processus	Présences cumulées (11 + 10 + 10 + 9 + 8 + 10)	72	58	80,6 %	Partiellement atteint
Processus	Taux moyen de participation	80 %	80,6 %	100,7 %	Atteint
Processus	Dépenses monétaires (hors contributions en nature)	3 060 €	3 092,90 €	101,1 %	Léger dépassement (+ 32,90 €, chapitre 8)

Type	Indicateur	Prévu	Réalisé	Taux d'atteinte	Statut
Résultat	Score moyen de connaissances après le cycle	7,0	7,17	102,4 %	Atteint
Résultat	Participants ayant progressé	75 %	100 %	133,3 %	Atteint
Résultat	Légumes secs au moins 2 fois par semaine	60 %	75 %	125,0 %	Atteint
Résultat	Participants satisfaits	85 %	91,7 %	107,8 %	Atteint

Calcul du taux d'atteinte = réalisé / prévu × 100. Exemple : présences : 58 / 72 × 100 = **80,6 %** ; ce taux est inférieur à 100 % pour l'indicateur « présences cumulées » (statut « partiellement atteint »), mais il dépasse la cible de 80 % fixée pour le taux de participation : les deux lectures sont cohérentes.

Étape 7 – Valorisation, veille et auto-évaluation (fiches F13 et F14)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F13 – Fiche de veille (exemple rempli)

Rubrique	Contenu
Date de la veille	15 avril 2026 (mise à jour le 26 octobre 2026)
Besoin	Vérifier le programme national de nutrition en vigueur pour la partie « contexte » de la fiche projet
Source	Ministère chargé de la Santé ; Réseau national nutrition santé ; mangerbouger.fr ; ecologie.gouv.fr (SNANC)
Type de source	Institutionnelle nationale (fiabilité élevée)
Information retenue	SNANC 2025-2030 publiée le 11/02/2026 ; PNNS 5 et PNA 4 (2026-2030) lancés le 08/04/2026 ; PNNS 5 : 3 axes, 20 mesures, objectif de − 30 % de surpoids et d'obésité chez les enfants
Conséquence pour le projet	Remplacer toutes les références au « PNNS 4 » par le PNNS 5 ; rattacher le projet à l'axe 2 ; citer l'objectif de réduction des inégalités
Diffusion	Note de 5 lignes envoyée à la tutrice et à la diététicienne ; enregistrée dans la base documentaire partagée (dossier « Politiques nutritionnelles »)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F14 – Check-list d'auto-évaluation d'Inès (extrait)

Critère (indicateurs du référentiel)	Auto- évaluation (1 à 4)	Justification, ajustement
Diagnostic posé à partir de données variées et sourcées	3	Données objectives et besoins exprimés solides ; données de santé locales limitées (une seule source)
Objectifs SMART cohérents avec le diagnostic	4	Chaque objectif renvoie à une cause de l'arbre à problèmes
Plan d'action et budget réalistes	3	Budget équilibré ; temps de préparation sous-estimé (38 h au lieu de 25 h prévues)
Communication adaptée au public	3	Flyers traduits appréciés ; message numérique peu efficace pour 3 familles
Évaluation construite et réalisée	3	Questionnaire avant/après exploité ; pas de mesure à distance (prévoir un appel à 3 mois)
Règles éthiques, RGPD, droit à l'image	4	Autorisations écrites, codes anonymes
Posture, écoute active, animation	3	À améliorer : gestion du temps de parole d'un participant très présent

Critère (indicateurs du référentiel)	Auto- évaluation (1 à 4)	Justification, ajustement
Ajustements proposés	—	Salade modifiée ; atelier 4 déplacé le mercredi pour les enfants ; rappel SMS la veille

À retenir – Ce que montre le fil rouge

- Un projet de santé publique part d'un **diagnostic** (données + besoins normatifs, exprimés, ressentis, observés), pas d'une idée du professionnel.
- Il **s'inscrit** dans les politiques en vigueur (PNNS 5, PRS, CLS) et mobilise des **partenaires**.
- Il combine plusieurs **modes d'intervention** (éducation pour la santé au service de la prévention sélective, démarche de promotion de la santé).
- Il est **évalué** avec des indicateurs de processus et de résultats, et ses limites sont reconnues.
- Toutes les fiches F1 à F14 sont **cohérentes entre elles** : c'est ce que le jury de l'épreuve E5 vérifie dans le dossier.

1.4 Approfondissements

1.4.1 Les données probantes en promotion de la santé

Une **donnée probante** est une information issue de la recherche ou de l'évaluation qui montre qu'une intervention est **efficace** (ou non) dans un contexte donné. En promotion de la santé, on combine trois sources : les **résultats de la recherche**, l'**expérience des professionnels** et les **savoirs des personnes concernées**. Santé publique France tient un **registre des interventions probantes ou prometteuses** en prévention et promotion de la santé (par exemple, des programmes de développement des compétences psychosociales à l'école, ou des programmes d'activité physique et de nutrition). Avant de concevoir un projet, il est recommandé de vérifier s'il existe une intervention déjà évaluée que l'on peut **adapter** (transférabilité) plutôt que de tout inventer.

Exemple – Ce que l'on sait de l'efficacité des actions en nutrition

- Les actions **multi-composantes** (éducation + modification de l'environnement + implication des familles) sont plus efficaces que l'information seule.
- Les actions sur l'**environnement** (offre scolaire, prix, étiquetage, reformulation) touchent toute la population et réduisent davantage les inégalités que l'éducation seule.
- Les ateliers culinaires améliorent les **compétences** et la **confiance** en cuisine et, à court terme, certains comportements déclarés (fruits et légumes) ; leurs effets à long terme sont moins documentés, d'où l'importance d'une évaluation bien construite.

Méthode – Trouver et utiliser une intervention probante

Étape 1 – Chercher : consulter le **registre des interventions probantes ou prometteuses** de Santé publique France, les fiches de la Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé et des structures régionales, les synthèses de l'OMS Europe.

Étape 2 – Vérifier : l'intervention a-t-elle été **évaluée** ? Sur quel public, dans quel pays, avec quels résultats ? Les résultats portent-ils sur des **comportements** ou seulement sur des connaissances ?

Étape 3 – Juger la transférabilité : mon public, mon territoire et mes moyens ressemblent-ils à ceux de l'intervention d'origine ? Qu'est-ce qui doit être **adapté** (langue, recettes, horaires) et qu'est-ce qui doit être **gardé** (les « fonctions clés » qui expliquent l'efficacité) ?

Étape 4 – Citer : dans le dossier E5, nommer l'intervention, sa source et sa date ; expliquer en une phrase ce que vous avez adapté.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.6 bis – Juger une action

Une mairie veut lutter contre le surpoids des enfants. Trois propositions sont faites : A) distribuer un dépliant sur l'équilibre alimentaire à toutes les familles ; B) un programme d'un an associant ateliers culinaires parents-enfants, modification des goûters servis au périscolaire et fontaines à eau dans les écoles ; C) une pesée des enfants en classe avec un courrier aux familles des enfants en surpoids.

1. Classez les propositions de la plus probablement efficace à la moins efficace, en justifiant avec les données probantes.
2. Quelle proposition pose un problème éthique ? Pourquoi ?

Corrigé – Exercice 1.6 bis

1. **B** d'abord : action **multi-composantes** (éducation + environnement + familles), qui touche tous les enfants. Ensuite **A** : l'information seule a peu d'effet sur les comportements et touche surtout les familles déjà sensibilisées (risque d'accroître les inégalités). **C** en dernier : un repérage sans proposition d'accompagnement n'est pas une intervention efficace.
2. **C** : la pesée en classe et le courrier ciblé exposent les enfants à la **stigmatisation** (section 1.4.4) ; le repérage doit se faire dans un cadre médical confidentiel (santé scolaire, médecin traitant), avec une orientation vers une prise en charge.

1.4.2 Les théories du changement de comportement : premier aperçu

Pour comprendre pourquoi « savoir » ne suffit pas, on utilise des modèles qui seront détaillés au chapitre 3 :

- **Modèle des croyances relatives à la santé** (*Health Belief Model*, Rosenstock, années 1950-1970) : une personne adopte un comportement si elle se sent **vulnérable**, si elle perçoit la **gravité** du problème, si elle juge les **bénéfices** supérieurs aux **obstacles**, avec un **déclencheur** à l'action et un sentiment d'**auto-efficacité**.
- **Modèle transthéorique des étapes du changement** (Prochaska et DiClemente, 1983) : précontemplation, contemplation, préparation, action, maintien (et rechute possible). L'action éducative s'adapte à l'étape de la personne.
- **Théorie sociale cognitive** (Bandura, 1977-1986) : le **sentiment d'efficacité personnelle** (« je suis capable de cuisiner des lentilles ») est un levier central ; il se développe par l'expérience réussie (d'où l'intérêt de **faire** en atelier), l'observation de pairs, l'encouragement.

Lien diététique – Dans le fil rouge

Faire cuisiner les familles elles-mêmes (et non leur faire une démonstration) développe l'**auto-efficacité** ; la dégustation partagée et le choix des recettes par le groupe mobilisent l'**influence sociale** positive ; le coût par portion calculé ensemble lève un **obstacle perçu** (« c'est cher »).

1.4.3 Le débat sur les aliments ultra-transformés

La classification **NOVA** (Carlos Monteiro, université de São Paulo, 2009) classe les aliments selon leur **degré de transformation** en quatre groupes : 1) aliments non ou peu transformés ; 2) ingrédients culinaires transformés (huile, sucre, sel) ; 3) aliments transformés (conserves, fromages, pain artisanal) ; 4) **aliments ultra- transformés** (formulations industrielles contenant des ingrédients peu ou pas utilisés en cuisine domestique : additifs cosmétiques, isolats de protéines, sirops…). De nombreuses études d'observation, dont la cohorte NutriNet-

Santé, associent une forte consommation d'ultra-transformés à un risque accru d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de mortalité. Les repères de 2019 recommandent de les **limiter**. Le débat porte sur la **définition** (NOVA est critiquée pour son manque de précision), sur la **causalité** (études observationnelles) et sur l'articulation avec le Nutri-Score (qui mesure la composition nutritionnelle, pas la transformation). Le PNNS 5 reconnaît l'enjeu et confie à l'ANSES l'élaboration d'une définition opérationnelle.

Outil	Ce qu'il mesure	Ce qu'il ne mesure pas	Exemple
Nutri-Score (A à E)	La **composition nutritionnelle** pour 100 g : énergie, sucres, graisses saturées, sel, fibres, protéines, fruits, légumes, légumineuses	Le degré de transformation, les additifs, le mode de production (bio), l'origine	Une boisson « zéro » sucre peut être bien classée tout en étant ultra-transformée
NOVA (groupes 1 à 4)	Le **degré de transformation** et les procédés industriels	La teneur en sucres, en sel ou en graisses	Une huile d'olive (groupe 2) est riche en lipides ; un pain complet artisanal (groupe 3) peut être salé
Label bio (AB, Eurofeuille)	Le **mode de production** agricole	La composition nutritionnelle	Un biscuit bio peut être très sucré

À vous de jouer – Exercice d'application 1.6 ter – Nutri-Score ou NOVA ?

Classez chaque aliment dans un groupe NOVA (1 à 4) : a) lentilles vertes sèches ; b) huile de colza ; c) pain de boulangerie (farine, eau, sel, levure) ; d) céréales du petit déjeuner fourrées au chocolat avec émulsifiant et arôme ; e) yaourt nature ; f) nuggets de poulet panés surgelés avec amidon modifié.

Puis expliquez en deux phrases à un groupe de parents pourquoi un produit classé A au Nutri-Score n'est pas forcément « peu transformé ».

Corrigé – Exercice 1.6 ter

a) Groupe **1** (non transformé). b) Groupe **2** (ingrédient culinaire). c) Groupe **3** (aliment transformé avec des ingrédients de cuisine). d) Groupe **4** (ultra-transformé : additifs cosmétiques). e) Groupe **1** (lait fermenté sans ajout). f) Groupe **4** (ultra-transformé : amidon modifié, procédés industriels).

Exemple d'explication : « Le Nutri-Score regarde ce que contient l'aliment : sucre, sel, gras, fibres. Il ne dit pas comment l'aliment a été fabriqué : pour choisir, regardez aussi la liste des ingrédients ; plus elle est courte et faite d'ingrédients que vous avez dans votre cuisine, mieux c'est. »

1.4.4 Promotion de la santé et non-stigmatisation du poids

La **stigmatisation du poids** (moqueries, discriminations, messages culpabilisants) est elle-même un facteur de risque : elle augmente le stress, les troubles du comportement alimentaire, l'évitement des soins et, paradoxalement, la prise de poids. Une déclaration de consensus internationale (*Nature Medicine*, 2020) appelle à l'éliminer. En pratique : parler de « personne vivant avec une obésité », éviter les images dégradantes, ne pas peser les enfants en public, centrer les actions sur la **santé** et le **plaisir** de manger plutôt que sur le poids, proposer des actions **universelles** (pour tous les enfants) plutôt que de désigner les enfants « en surpoids ».

Formulations à éviter	Formulations à préférer	Pourquoi
« Les obèses », « les gros »	« Les personnes vivant avec une obésité »	On nomme la personne avant la maladie
« Lutter contre l'obésité des enfants » (sur une affiche destinée aux familles)	« Bien manger et bouger en famille »	Le message vise tous les enfants et ne désigne personne
« Aliments interdits », « mauvais aliments »	« Aliments à limiter », « à garder pour les moments de plaisir »	On évite la culpabilité et la moralisation

Formulations à éviter	Formulations à préférer	Pourquoi
Photo d'un corps sans tête, ventre en gros plan	Photo de personnes de corpulences variées en activité	On évite l'image dégradante
« Il faut perdre du poids »	« On peut améliorer sa santé quel que soit son poids »	On centre l'action sur la santé et le plaisir

À vous de jouer – Exercice d'application 1.6 quater – Réécrire un message

Réécrivez ces trois phrases trouvées sur l'affiche d'une action en collège pour qu'elles ne soient pas stigmatisantes : a) « Stop à l'obésité : les sodas sont interdits ! » ; b) « Élèves en surpoids : inscrivez-vous à l'atelier sport » ; c) « Les mauvaises habitudes des familles font grossir les enfants ».

Corrigé – Exercice 1.6 quater

a) « Envie de te désaltérer ? L'eau, c'est gratuit et à volonté : découvre nos eaux aromatisées maison. » b) « Atelier sport pour tous, tous niveaux, le mardi midi : viens essayer ! » c) « Cuisiner ensemble, c'est bon pour toute la famille : découvrez nos ateliers parents-enfants. » Les trois réécritures s'adressent à **tous**, valorisent le **plaisir** et une **action positive**, et ne désignent personne.

1.4.5 Santé publique, alimentation et climat

Le système alimentaire représente environ **un quart de l'empreinte carbone** de la consommation des ménages français (ordre de grandeur cité par l'ADEME et le Haut Conseil pour le climat). Une alimentation plus **végétale**, **de saison**, **locale** quand c'est pertinent, **peu transformée** et **sans gaspillage** est généralement favorable à la fois à la santé et au climat : c'est le principe des « co-bénéfices » qui fonde la SNANC. La commission **EAT-Lancet** (2019) a proposé un « régime de santé planétaire » ; le HCSP (2025) recommande pour le PNNS 5 une diminution d'environ 50 % de la consommation de viande et une augmentation des produits végétaux. Le diététicien veille toutefois à la **couverture des besoins** (fer, vitamine B12, calcium, iode) et à l'**acceptabilité** culturelle et économique des changements.

Calcul – Diversifier les sources de protéines : combien faut-il manger pour obtenir 20 g de protéines ?

Données (table Ciqual 2025, ANSES, pour 100 g d'aliment cuit) : steak haché de bœuf 15 % MG cuit : 23,6 g de protéines, 2,6 mg de fer, 0 g de fibres, 239 kcal ; lentille verte cuite à l'eau : 10,1 g, 2,45 mg, 8,45 g, 125 kcal ; pois chiche cuit à l'eau : 8,31 g, 1,3 mg, 8,2 g, 148 kcal ; tofu nature : 13,4 g, 2,4 mg, fibres < 0,5 g (comptées 0), 147 kcal.

Étape 1 – Quantité pour 20 g de protéines = 20 / teneur × 100. Steak haché : 20 / 23,6 × 100 = **84,7 g** ; lentilles : 20 / 10,1 × 100 = **198,0 g** ; pois chiches : 20 / 8,31 × 100 = **240,7 g** ; tofu : 20 / 13,4 × 100 = **149,3 g**.

Étape 2 – Ce qu'apporte cette quantité : steak haché : 2,2 mg de fer, 0 g de fibres, 203 kcal ; lentilles : 4,9 mg de fer, 16,7 g de fibres, 248 kcal ; pois chiches : 3,1 mg de fer, 19,7 g de fibres, 356 kcal ; tofu : 3,6 mg de fer, 0 g de fibres, 219 kcal.

Interprétation : une assiette de lentilles (environ 200 g cuites) apporte autant de protéines qu'un steak haché, plus de fer et plus de la moitié des 30 g de fibres conseillés par jour. Attention : le fer des végétaux (fer non héminique) est moins bien absorbé que celui de la viande ; on améliore son absorption avec une source de vitamine C dans le repas (crudités, agrumes). C'est un exemple de **co-bénéfice** santé et climat à présenter en atelier.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.6 quinquies – Argumenter pour un menu végétarien

Le responsable d'une cantine craint que le menu végétarien hebdomadaire « manque de protéines ». Avec les données du calcul ci-dessus, rédigez une réponse de 5 lignes qui cite deux chiffres, un point de vigilance et

une proposition de plat.

Corrigé – Exercice 1.6 quinquies (exemple de réponse)

« Selon la table Ciqual 2025, 200 g de lentilles cuites apportent environ 20 g de protéines, autant qu'un steak haché de 85 g, et en plus 16,7 g de fibres. Le menu végétarien peut donc couvrir le besoin en protéines du repas. Le point de vigilance est le fer, moins bien absorbé : on ajoute une crudité ou un agrume au menu. Je propose un dahl de lentilles corail avec du riz et une salade de carottes au citron. » Le correcteur valorise : deux chiffres sourcés, la vigilance sur le fer, une proposition concrète.

1.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – L'approche par les capabilités (Amartya Sen)

Pour l'économiste Amartya Sen (prix Nobel 1998), la justice sociale ne se mesure pas aux ressources possédées mais aux **capabilités** : les libertés réelles d'une personne d'être et de faire ce qu'elle valorise. Appliquée à l'alimentation, cette approche montre qu'il ne suffit pas de **savoir** ce qu'est une alimentation équilibrée ni même d'avoir un revenu : il faut aussi avoir le **temps**, l'**équipement**, l'**accès physique** aux commerces, les **compétences** et la **liberté** de choisir. Elle fonde la notion de **droit à l'alimentation** et les expérimentations de « sécurité sociale de l'alimentation » débattues en France depuis 2019.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La syndémie mondiale (Swinburn et coll., *The Lancet*, 2019)

La commission du *Lancet* sur l'obésité propose le concept de **syndémie mondiale** : l'obésité, la dénutrition et le changement climatique sont trois pandémies qui **interagissent** et partagent des **déterminants communs** (systèmes alimentaires, transports, urbanisme, utilisation des terres, intérêts commerciaux). Elle appelle à des actions « à double ou triple bénéfice » et à limiter l'influence des grandes industries sur les politiques publiques : c'est le cadre intellectuel des stratégies intégrées comme la SNANC.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Évaluer la complexité : l'évaluation réaliste

Les interventions de promotion de la santé sont **complexes** (plusieurs composantes, plusieurs acteurs, contextes variables). L'**évaluation réaliste** (Pawson et Tilley, 1997) ne demande pas seulement « est-ce que ça marche ? », mais « **qu'est-ce qui marche, pour qui, dans quelles circonstances et pourquoi ?** » ; elle formule des configurations **contexte – mécanisme – effet**. Exemple : dans un quartier où les familles se connaissent (contexte), un atelier cuisine crée de l'entraide (mécanisme) qui maintient la pratique culinaire après le projet (effet). Le Medical Research Council britannique a publié en 2021 un cadre de référence actualisé pour le développement et l'évaluation des interventions complexes.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La santé dans toutes les politiques et les déterminants commerciaux de la santé

La déclaration d'Helsinki (2013) invite tous les secteurs (agriculture, économie, urbanisme, éducation) à évaluer l'**impact sur la santé** de leurs décisions (**évaluation d'impact sur la santé, EIS**). Plus récemment, l'OMS et *The Lancet* (série 2023) ont mis en avant les **déterminants commerciaux de la santé** : les stratégies des entreprises (marketing, lobbying, formulation des produits, prix) influencent la santé des populations. Ces travaux éclairent les débats sur l'encadrement du marketing alimentaire destiné aux enfants et sur le caractère volontaire du Nutri-Score.

1.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Consultation et santé publique

Une diététicienne libérale constate que beaucoup d'enfants qu'elle reçoit en consultation pour surpoids viennent de la même école. **Lien** : la consultation (BC1, soin individuel, prévention tertiaire ou secondaire) révèle un **problème de santé publique** ; elle peut alerter la santé scolaire et proposer une action **universelle** dans l'école (BC3) plutôt que de multiplier les consultations. Elle veille à ne pas stigmatiser les enfants et à respecter le **secret professionnel** (aucune information individuelle transmise).

Situation bc1 – De l'ETP à l'atelier ouvert

Un programme d'ETP « diabète » d'un hôpital souhaite proposer un atelier cuisine ouvert aux habitants du quartier. **Lien** : il faut distinguer l'**ETP** (réservée aux patients du programme déclaré à l'ARS) et l'**éducation pour la santé** ouverte à tous (prévention primaire) ; les objectifs, les messages et l'évaluation ne sont pas les mêmes.

Situation bc2 – Restauration scolaire et EGalim

Le diététicien d'une cuisine centrale (BC2) doit atteindre les objectifs EGalim et introduire un deuxième repas végétarien par semaine. **Lien BC3** : accompagner ce changement par une action d'**éducation au goût** dans les écoles (ateliers de dégustation de légumineuses), une **communication** vers les parents (plan de communication) et une **évaluation** (taux de consommation, gaspillage, satisfaction).

Situation bc2 – Former les professionnels

Le CCAS demande de former les aides à domicile à repérer la dénutrition des personnes âgées. **Lien** : compétence C2.6 (former les professionnels) au service d'une action de **prévention secondaire** (repérage précoce), inscrite dans le PNNS 5 (prévention de la dénutrition).

Situation bc3 – Répondre à un appel à projets

L'ARS lance un appel à projets « Nutrition et précarité ». Une association d'aide alimentaire vous sollicite. **Compétences** : C3.1 (diagnostic, objectifs, fiche projet, budget), C3.4 (veille sur les priorités du PRS et du PNNS 5), C3.5 (présentation du projet aux partenaires), C3.6 (dépôt du dossier sur une plateforme sécurisée, gestion des données des bénéficiaires).

Situation bc3 – Une demande inadaptée

Un directeur d'école vous demande une intervention d'une heure « pour expliquer aux enfants en surpoids qu'il faut moins manger ». **Analyse** : la demande est **stigmatisante** et fondée sur l'approche informative ; vous proposez une action **universelle** (toute la classe), **participative** (éducation sensorielle, découverte des fruits et légumes), associée à une action sur l'environnement (goûters, fontaine à eau) et à l'implication des parents, en cohérence avec la Charte d'Ottawa.

Méthode 1 – Présenter le cadre de son action en deux minutes (oral E5)

Le jury de l'épreuve E5 attend que vous situiez votre action dans son **cadre institutionnel et politique** (savoirs « enjeux de santé publique » du guide 2025). Cette présentation tient en deux minutes et suit toujours le même plan, du général au particulier.

Étape	Ce que vous dites	Exemple (fil rouge)	Durée
1. Le problème de santé	Le problème, chiffré et sourcé, au niveau national puis local	« 17 % des 6-17 ans sont en surpoids en France (Esteban 2015) ; 14 % des enfants de grande section des Tilleuls, contre 9 % dans le département (santé scolaire, 2026). »	30 s
2. Les politiques	La stratégie et le programme national, puis le niveau régional et local	« Le PNNS 5 vise une baisse de 30 % du surpoids des enfants, de 20 % chez ceux des familles défavorisées ; le PRS en fait une priorité ; le CLS de Valmont a une fiche-action nutrition. »	30 s
3. Le mode d'intervention	Promotion, prévention (OMS et Gordon), éducation (nutritionnelle, alimentaire, sensorielle)	« C'est une action de promotion de la santé et de prévention primaire, sélective, avec une éducation alimentaire et sensorielle. »	20 s
4. Les acteurs	Décideur, financeur, opérateurs, partenaires	« L'ARS finance par appel à projets ; le centre social porte le projet ; l'épicerie solidaire et la PMI sont partenaires. »	20 s
5. Votre place	Votre rôle et vos compétences	« J'ai réalisé le diagnostic, conçu et animé les ateliers, et construit l'évaluation (C3.1, C3.2, C3.5). »	20 s

Le jury attend – Les erreurs qui coûtent des points

- Citer un programme **périmé** (PNNS 4 au lieu du PNNS 5) ou présenter comme adopté un texte qui n'est qu'un projet (la SNS 2023-2033, non adoptée en mai 2026).
- Donner un chiffre **sans source ni année**.
- Confondre **promotion de la santé** et **éducation pour la santé**, ou qualifier une action collective d'**ETP**.
- Oublier les **acteurs** et présenter l'action comme celle d'une personne seule.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.7 – Mon cadre en deux minutes

Rédigez, pour votre action de stage (ou, à défaut, pour l'action « Bouge et mange » d'un club sportif d'adolescents), les cinq phrases du tableau ci-dessus. Chronométrez-vous à voix haute : vous devez tenir en deux minutes.

Corrigé – Exercice 1.7 (exemple pour le club sportif)

1. « Selon Esteban, 17 % des 6-17 ans sont en surpoids ; dans le club, 6 adolescents sur 10 sautent le petit déjeuner avant l'entraînement du samedi (questionnaire, mars 2027). » 2. « L'action répond au PNNS 5 (comportements nutritionnels sains et milieux de vie) et à la Stratégie nationale sport-santé ; le PRS de la région cible la santé des jeunes. » 3. « C'est une action de promotion de la santé dans un milieu de vie, de prévention primaire universelle (tous les licenciés), avec une éducation nutritionnelle. » 4. « Le club porte le projet ; la commune et la mutuelle financent ; le comité départemental et l'infirmière du collège sont partenaires. » 5. « J'ai réalisé le questionnaire, animé deux ateliers petit déjeuner et évalué l'action. » Les données du club sont fictives : dans votre dossier, chaque chiffre doit venir de votre propre recueil ou d'une source datée.

Méthode 2 – Lire de façon critique un document de santé publique

Le référentiel (compétence C3.4) demande de **sélectionner des sources fiables** et d'en faire une **analyse critique**. Avant d'utiliser un document (article, rapport, affiche, page web), posez-vous six questions.

Question	Ce que l'on vérifie	Signal d'alerte
Qui ?	L'auteur ou l'organisme, sa compétence, ses liens d'intérêts	Document d'une marque ou d'un lobby présenté comme neutre
Quand ?	La date de publication et la date du recueil des données	Chiffre de plus de 10 ans présenté comme actuel
Quoi ?	Le type de document : étude, avis d'expert, opinion, publicité	Témoignage présenté comme une preuve
Sur qui ?	La population étudiée et son effectif	Résultat sur 30 personnes généralisé à toute la France
Comment ?	La méthode : données mesurées ou déclarées, étude d'observation ou essai	Lien de cause à effet affirmé à partir d'une simple association
Et alors ?	La cohérence avec les recommandations officielles (HCSP, ANSES, Santé publique France)	Conseil contraire aux repères officiels, sans débat scientifique

À vous de jouer – Exercice d'application 1.8 – Analyser un document

Document (fictif, construit pour l'exercice) : une page web d'un fabricant de céréales, datée de 2026, titre « Le petit déjeuner aux céréales rend les enfants plus performants à l'école ». Le texte cite « une étude » menée en 2009 auprès de 42 enfants d'une école privée, dont les parents déclaraient ce que mangeait leur enfant ; les enfants qui mangeaient des céréales avaient de meilleures notes.

1. Appliquez les six questions de la méthode.
2. Pouvez-vous utiliser ce document dans votre dossier E5 ? Si oui, comment ?

Corrigé – Exercice 1.8

1. **Qui ?** Un fabricant : conflit d'intérêts. **Quand ?** Page de 2026, mais données de 2009 (17 ans). **Quoi ?** Un texte promotionnel qui résume une étude non référencée. **Sur qui ?** 42 enfants d'une seule école privée : effectif faible, population non représentative (niveau social plus élevé). **Comment ?** Données déclarées par les parents ; étude d'observation : on ne peut pas conclure que les céréales « rendent » les enfants performants (le niveau social peut expliquer à la fois le petit déjeuner et les notes). **Et alors ?** Les repères officiels recommandent un petit déjeuner, sans privilégier un produit de marque.
2. Pas comme une **source**. On peut l'utiliser comme **exemple** de document à analyser avec le public (atelier d'éducation critique à la publicité), ce qui développe la littératie en santé (chapitre 5).

1.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Concepts

- **Santé (OMS, 1946)** : « état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». Critique : idéal, statique ; la santé est aussi une capacité d'adaptation et une **ressource de la vie quotidienne** (Ottawa, 1986).
- **Une seule santé / One Health** : santé humaine, animale et des écosystèmes interdépendantes (Quadripartite OMS-FAO-OMSA-PNUE) ; cadre de toute intervention du BC3 (guide 2025).
- **Santé publique** : actions organisées et collectives pour maintenir et améliorer la santé de la population en

agissant sur ses déterminants (Winslow, 1920 ; CSP art. L. 1411-1).

- **Paradoxe de Rose** : un grand nombre de personnes à faible risque produit plus de cas qu'un petit nombre à haut risque : il faut des actions populationnelles.
- **Danger** (capacité à nuire) ≠ **risque** (probabilité, = danger × exposition) ; **facteur de risque** = association, pas forcément cause.

À retenir – Modes d'intervention

- **Surveillance** (recueil continu, analyse, diffusion) et **veille sanitaire** (détection des signaux, alerte) : Santé publique France, ANSES.
- **Promotion de la santé** (Ottawa, 21/11/1986) : processus qui confère aux populations les moyens d'un plus grand contrôle sur leur santé ; **5 domaines** (politique saine, milieux favorables, action communautaire, aptitudes individuelles, réorientation des services) et **3 stratégies** (plaider, conférer les moyens, servir de médiateur).
- **Prévention** (OMS 1948) : primaire (incidence), secondaire (prévalence, dépistage), tertiaire (complications), quaternaire (surmédicalisation) ; Gordon (1983) : universelle, sélective, indiquée.
- **Éducation pour la santé** : nutritionnelle, alimentaire, sensorielle ; approche participative et compétences psychosociales.
- **ETP** : soin, patients atteints de maladie chronique, programme déclaré à l'ARS (BC1) ≠ éducation pour la santé.
- **Universalisme proportionné** (Marmot, 2010) : pour tous, plus intensément pour les plus défavorisés.

À retenir – Acteurs et politiques

- National : DGS (PNNS), DGAL (PNA, EGalim), Santé publique France, ANSES, HAS, HCSP, CNA ; régional : **ARS** (PRS = COS 10 ans + SRS 5 ans + PRAPS ; appels à projets), DRAAF ; local : CLS, PAT, contrats de ville, communes, CCAS, PMI.
- **SNANC 2025-2030** (loi Climat et résilience, art. 265) publiée le **11/02/2026** ; **PNNS 5** et **PNA 4** (2026-2030) lancés le **08/04/2026** ; PNNS 5 : 3 axes, 20 mesures, – 30 % de surpoids et d'obésité chez les enfants et adolescents.
- **Repères 2019** (Santé publique France) : augmenter (fruits et légumes, légumes secs, fruits à coque, activité physique), aller vers (complets, colza-noix-olive, poisson 2/sem., 2 produits laitiers, saison/local/bio), réduire (alcool, boissons sucrées, produits gras-sucrés-salés et ultra-transformés, charcuterie 150 g/sem., viande 500 g/sem., sel, sédentarité).
- **EGalim** : 50 % durables et de qualité dont 20 % bio ; 60 % pour viandes et poissons (2024) ; menu végétarien hebdomadaire à l'école. **Nutri-Score** : facultatif, nouvel algorithme (arrêté du 14/03/2025).

À retenir – Chiffres-clés (à dater et sourcer dans vos écrits)

Donnée	Valeur (source, année)
Obésité de l'adulte	18,1 % (OFÉO, 2024) ; 17 % mesuré (ESTEBAN, 2015)
Surpoids des 6-17 ans	17 % dont 4 % d'obésité (ESTEBAN, 2015)
Précarité alimentaire	16 % (Crédoc, 2022)
Atteinte des 5 fruits et légumes	30 % des adultes, 20 % des enfants (HCSP, 2025)
Fibres < 25 g/jour	90 % des adultes (HCSP, 2025)
Espérance de vie	85,9 ans (F), 80,3 ans (H) (Insee, 2025)
Écart d'espérance de vie selon le revenu	≈ 13 ans chez les hommes (Insee, 2018)
EGalim, achats 2023	≈ 25,5 % durables et de qualité, 12,1 % bio (bilan 2024)

Donnée	Valeur (source, année)
PAT	≈ 450 reconnus (juillet 2025) ; objectif 80 % du territoire (SNANC)
Fil rouge (fictif)	Repas complet à 1,38 €/personne ; score 4,75 → 7,17/10 ; légumes secs 25 % → 75 %

1.8 Entraînement

1.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – La définition de la santé de l'OMS date de :

a) 1946 (signature de la Constitution), entrée en vigueur en 1948 **b)** 1978 (Alma-Ata) **c)** 1986 (Ottawa) **d)** 2004 (loi relative à la politique de santé publique)

QCM 2 – Selon la Charte d'Ottawa, la promotion de la santé :

a) vise une maladie précise **b)** confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé **c)** se limite à l'information du public **d)** agit sur les politiques publiques et les milieux de vie

QCM 3 – Parmi ces domaines, lequel n'est PAS l'un des cinq domaines d'action de la Charte d'Ottawa ?

a) Créer des milieux favorables **b)** Renforcer l'action communautaire **c)** Développer le dépistage organisé **d)** Réorienter les services de santé

QCM 4 – La prévention primaire vise à réduire :

a) la prévalence d'une maladie **b)** l'incidence d'une maladie **c)** les complications d'une maladie installée **d)** la surmédicalisation

QCM 5 – Le repérage du rebond d'adiposité précoce sur la courbe de corpulence d'un enfant relève de la prévention :

a) primaire **b)** secondaire **c)** tertiaire **d)** quaternaire

QCM 6 – Une action réservée aux familles d'un quartier prioritaire, sans signe de maladie, est une prévention (Gordon) :

a) universelle **b)** sélective **c)** indiquée **d)** tertiaire

QCM 7 – L'éducation thérapeutique du patient :

a) est une forme d'éducation pour la santé destinée à toute la population **b)** s'adresse à des personnes atteintes d'une maladie chronique **c)** est encadrée par la loi HPST du 21 juillet 2009 **d)** relève de la prévention tertiaire

QCM 8 – Le risque se définit comme :

a) la propriété intrinsèque d'un agent à provoquer un effet néfaste **b)** la probabilité de survenue d'un effet néfaste, compte tenu du danger et de l'exposition **c)** une caractéristique associée à une moindre probabilité de maladie **d)** le nombre de nouveaux cas dans une population

QCM 9 – Les études INCA sont conduites par :

a) Santé publique France **b)** l'ANSES **c)** la HAS **d)** l'Insee

QCM 10 – Le projet régional de santé (PRS) :

a) est élaboré par l'ARS **b)** comprend un cadre d'orientation stratégique sur 10 ans **c)** comprend un schéma régional de santé sur 5 ans **d)** comprend un PRAPS destiné aux personnes les plus démunies

QCM 11 – La SNANC 2025-2030 :

a) est prévue par la loi Climat et résilience du 22 août 2021 **b)** a été publiée le 11 février 2026 **c)** remplace la loi EGalim **d)** détermine les orientations du PNNS et du PNA

QCM 12 – Le PNNS en vigueur en octobre 2026 est :

a) le PNNS 3 **b)** le PNNS 4 (2019-2023) **c)** le PNNS 5 (2026-2030) **d)** le PNAN 2019-2023

QCM 13 – Selon les repères de Santé publique France (2019), il est recommandé de consommer des légumes secs :

a) au moins une fois par mois **b)** au moins deux fois par semaine **c)** tous les jours obligatoirement **d)** uniquement en remplacement du pain

QCM 14 – La loi EGalim impose en restauration collective :

a) 50 % de produits durables et de qualité dont au moins 20 % de produits bio **b)** 100 % de produits locaux **c)** un menu végétarien au moins une fois par semaine en restauration scolaire **d)** l'affichage obligatoire du Nutri-Score sur les menus

QCM 15 – Le Nutri-Score :

a) est obligatoire sur tous les produits vendus en France **b)** classe les produits de A à E **c)** a un nouvel algorithme applicable en France depuis l'arrêté du 14 mars 2025 **d)** mesure le degré de transformation des aliments

QCM 16 – L'universalisme proportionné consiste à :

a) cibler uniquement les plus défavorisés **b)** proposer la même action avec la même intensité à tous **c)** proposer une action à tous, avec une intensité proportionnelle au désavantage social **d)** supprimer les actions universelles

QCM 17 – Le paradoxe de la prévention (Rose) signifie que :

a) la prévention est inutile **b)** la majorité des cas provient souvent du grand nombre de personnes à risque faible ou modéré **c)** il faut uniquement traiter les personnes à haut risque **d)** une mesure utile à la population apporte souvent peu à chaque individu

QCM 18 – Lequel de ces organismes assure la veille sanitaire en France ?

a) Santé publique France **b)** le CNA **c)** l'EFSA **d)** la DGCCRF

QCM 19 – Le modèle de Dahlgren et Whitehead :

a) classe les niveaux de prévention **b)** représente les déterminants de la santé en couches concentriques **c)** place au centre l'âge, le sexe et les facteurs héréditaires **d)** montre que les comportements dépendent des conditions de vie

QCM 20 – Une campagne télévisée nationale « Manger Bouger » relève de :

a) l'éducation pour la santé informative **b)** la prévention primaire universelle **c)** l'éducation thérapeutique **d)** la prévention tertiaire

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a. Constitution signée le 22 juillet 1946, entrée en vigueur le 7 avril 1948. Alma-Ata (1978) concerne les soins de santé primaires ; Ottawa (1986) la promotion de la santé.

2. b, d. La promotion de la santé ne vise pas une maladie précise (c'est la prévention) et ne se limite pas à l'information : elle agit sur les politiques, les milieux, la communauté, les aptitudes et les services.

3. c. Le dépistage relève de la prévention secondaire, pas des cinq domaines d'Ottawa.

4. b. La prévention primaire évite l'apparition de nouveaux cas (incidence) ; la secondaire réduit la prévalence ; la tertiaire les complications ; la quaternaire la surmédicalisation.

5. b. Le repérage précoce d'un signe (avant l'installation de l'obésité et de ses complications) est une prévention secondaire.

6. b. Sous-groupe exposé à un risque (précarité), sans signe de maladie : prévention sélective.

7. b, c, d. L'ETP n'est pas de l'éducation pour la santé « tout public » : elle s'adresse aux patients (art. L. 1161-1 du CSP issu de la loi HPST) et relève du soin et de la prévention tertiaire.

8. b. La réponse a définit le danger ; c le facteur de protection ; d l'incidence.

9. b. INCA = études individuelles nationales des consommations alimentaires de l'ANSES (ESTEBAN = Santé publique France).

10. a, b, c, d. Les quatre affirmations sont exactes (art. L. 1434-1 et suivants du CSP).

11. a, b, d. La SNANC ne remplace pas EGalim : elle rappelle et prolonge ses objectifs.

12. c. PNNS 5 lancé le 8 avril 2026. Citer le PNNS 4 comme « en vigueur » serait une erreur de veille.

13. b. Légumes secs au moins 2 fois par semaine (catégorie « augmenter »).

14. a, c. L'affichage du Nutri-Score n'est pas obligatoire ; le « 100 % local » n'existe pas (le critère « local » n'est d'ailleurs pas autorisé en tant que tel par le droit des marchés publics).

15. b, c. Le Nutri-Score est facultatif (droit européen) et mesure la composition nutritionnelle, pas la transformation (c'est la classification NOVA).

16. c. Définition de Marmot (2010).

17. b, d. Le paradoxe justifie les actions populationnelles en complément des actions à haut risque.

18. a. Le CNA est une instance de concertation ; l'EFSA est européenne ; la DGCCRF contrôle la loyauté commerciale.

19. b, c, d. Les niveaux de prévention, c'est la classification de l'OMS.

20. a, b. Communication de masse, informative, destinée à toute la population, avant toute maladie.

1.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les niveaux de prévention

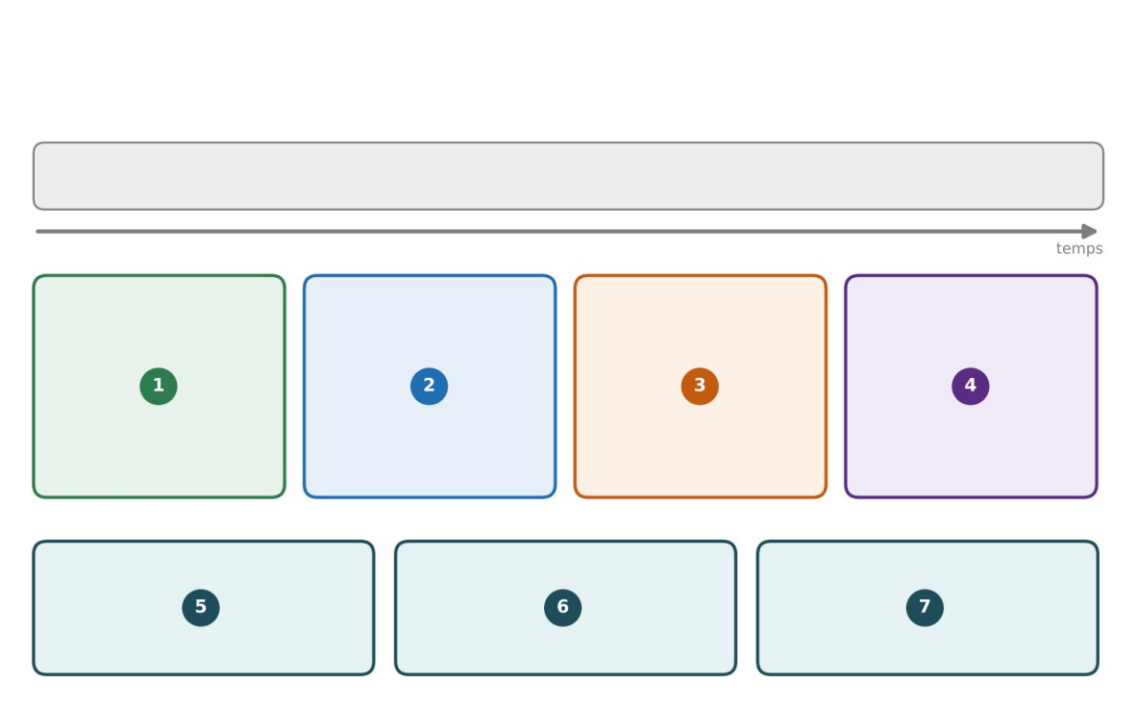


Figure 1.15 – Schéma à légender (niveaux de prévention)

Complétez les légendes 1 à 7 : nom du niveau ou du type de prévention, auteur et date de la classification, indicateur que chaque niveau fait baisser, un exemple en nutrition pour chacun.

Corrigé

1. Prévention primaire (OMS, 1948) : avant la maladie ; diminue l'**incidence** ; exemple : atelier cuisine pour

tous, réduction du sel dans le pain.

2. Prévention secondaire : au début de la maladie ; diminue la **prévalence** par le dépistage ; exemple : repérage du surpoids en santé scolaire, dépistage de la dénutrition.

3. Prévention tertiaire : maladie installée ; diminue les **complications et récidives** ; exemple : suivi diététique de la personne diabétique, ETP.

4. Prévention quaternaire (Jamoulle, 1986) : évite la **surmédicalisation** ; exemple : déconseiller un régime d'éviction sans diagnostic.

5. Prévention universelle (Gordon, 1983) : toute la population ; exemple : repères PNNS.

6. Prévention sélective : sous-groupe exposé ; exemple : familles d'une épicerie solidaire.

7. Prévention indiquée : personnes présentant déjà des facteurs de risque ; exemple : programme pour enfants en surpoids repérés.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : les déterminants de la santé

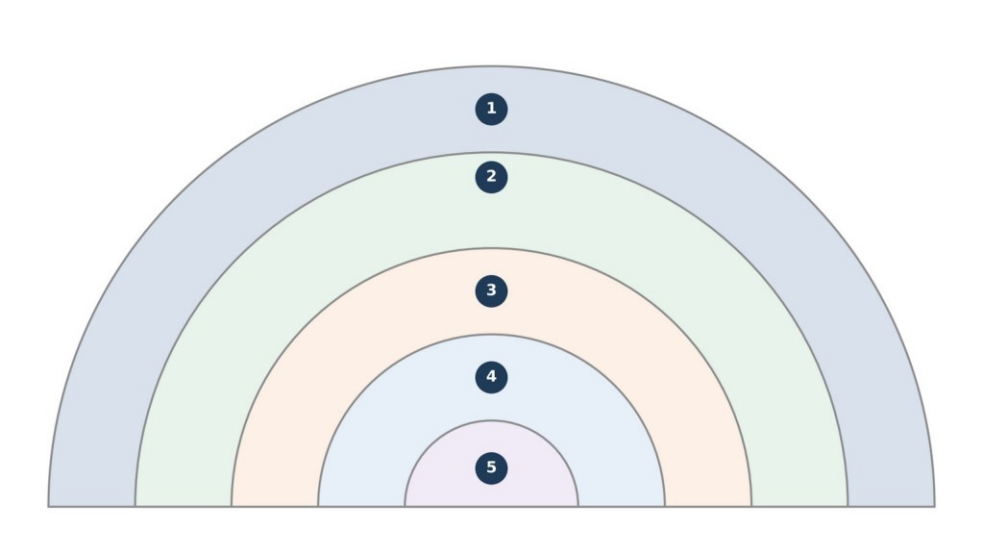


Figure 1.16 – Schéma à légender (modèle des déterminants)

Donnez le nom du modèle et sa date, puis légendez les couches 1 à 5. Pour chaque couche, donnez un exemple de déterminant de l'alimentation d'un enfant vivant dans un quartier prioritaire.

Corrigé

Modèle de **Dahlgren et Whitehead (1991)**.

1. Âge, sexe, facteurs héréditaires : âge de l'enfant (8 ans), préférences innées pour le sucré.

2. Style de vie personnel : grignotage devant les écrans, faible activité physique.

3. Réseaux sociaux et communautaires : habitudes familiales, influence des camarades, soutien des voisins, centre social.

4. Conditions de vie et de travail : logement exigu sans cuisine équipée, offre alimentaire du quartier (supérette, restaurants rapides), cantine, horaires de travail des parents, chômage.

5. Conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales : prix des aliments, minima sociaux, politiques alimentaires (EGalim, Nutri-Score), publicité, culture alimentaire.

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : l'architecture des politiques

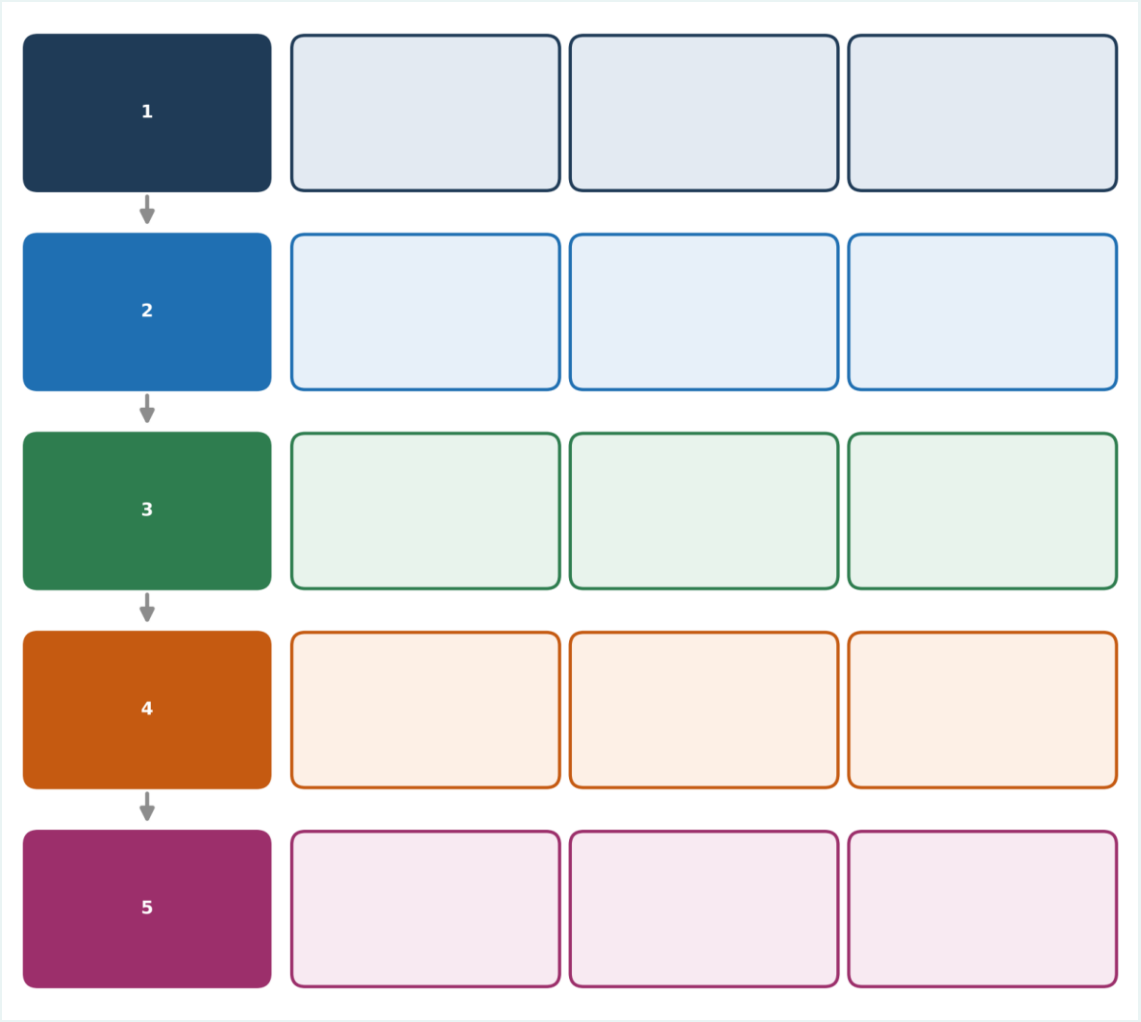


Figure 1.17 – Schéma à légender (architecture des politiques nutritionnelles)

Nommez les 5 niveaux (1 à 5) et placez dans les bonnes cases : OMS ; SNANC 2025-2030 ; PNNS 5 ; PNA 4 ; ARS – PRS ; DRAAF ; CLS ; PAT ; loi EGalim ; Stratégie nationale de santé ; règlement INCO ; centre social ; diététicien.

Corrigé

1. Mondial et européen : OMS ; règlement INCO (Union européenne).

2. National – stratégies : Stratégie nationale de santé (dernière adoptée : 2018-2022) ; SNANC 2025-2030.

3. National – programmes et lois : PNNS 5 ; PNA 4 ; loi EGalim.

4. Régional : ARS – PRS ; DRAAF.

5. Local et terrain : CLS ; PAT ; centre social ; diététicien.

À vous de jouer – Exercice 4 – Schéma à légender : la démarche de projet

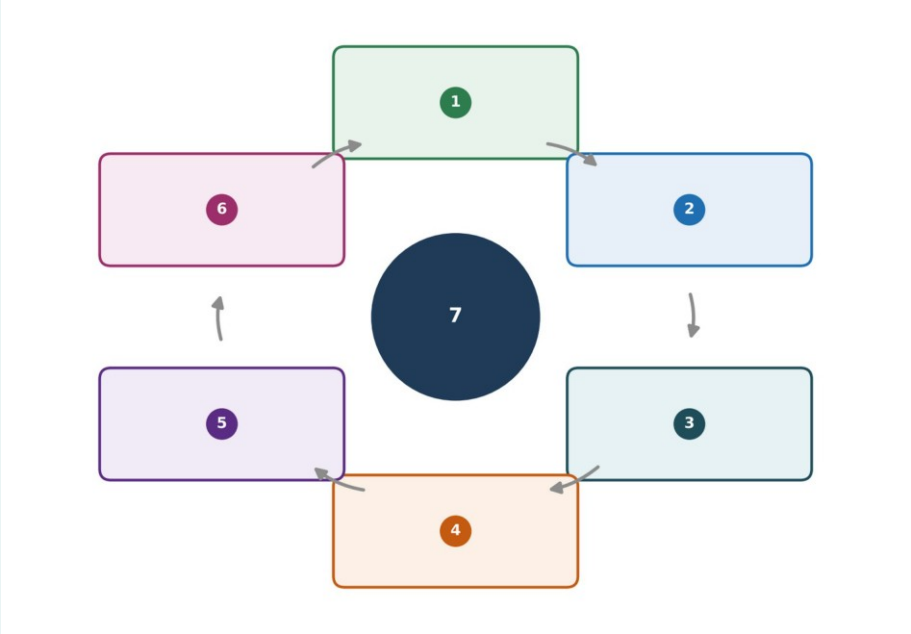


Figure 1.18 – Schéma à légender (démarche de projet)

Nommez les étapes 1 à 6 et le centre 7, puis placez les fiches F1 à F14.

Corrigé

1. Analyse de situation et diagnostic (F1, F2). 2. Priorités et objectifs (F3). 3. Conception et plan d'action (F4, F5, F6). 4. Mise en œuvre et pilotage (F7, F8, F9, F10). 5. Évaluation (F11, F12). 6. Valorisation et ajustements (F13, F14). 7. Démarche de projet en santé publique (cycle).

À vous de jouer – Exercice 5 – Classer des actions (tableau)

Classez les 8 actions suivantes selon le mode d'intervention dominant et le niveau de prévention : a) taxe sur les boissons sucrées ; b) dépistage de la dénutrition à l'admission en EHPAD ; c) classe du goût en CE1 ; d) déclaration d'une TIAC à l'ARS ; e) programme d'ETP « insuffisance rénale » ; f) jardin partagé co-géré par les habitants ; g) enquête Albane ; h) atelier « repas à petit prix » à l'épicerie solidaire.

Corrigé

Action	Mode d'intervention	Prévention
a	Promotion de la santé (politique publique saine, fiscalité)	Primaire, universelle
b	Prévention (dépistage)	Secondaire, sélective (population âgée à risque)
c	Éducation pour la santé (sensorielle)	Primaire, universelle (toute la classe)
d	Veille sanitaire (signal, alerte)	Permet la prévention de nouveaux cas (primaire)
e	ETP (soin, BC1)	Tertiaire
f	Promotion de la santé (action communautaire, milieu favorable)	Primaire, universelle ou sélective selon le quartier
g	Surveillance	– (production de données)
h	Éducation pour la santé (alimentaire)	Primaire, sélective

À vous de jouer – Exercice 6 – Paradoxe de Rose (calcul)

Dans une ville de 50 000 adultes, 4 000 ont un IMC ≥ 35 (risque de diabète sur 5 ans : 60 pour 1 000) et 46 000 ont un IMC < 35 (risque : 8 pour 1 000). a) Calculez le nombre de cas de diabète attendus dans chaque groupe sur 5 ans. b) Quelle part des cas provient du groupe « à faible risque » ? c) Concluez.

Corrigé

a) Groupe à haut risque : 4 000 × 60 / 1 000 = **240 cas**. Groupe à faible risque : 46 000 × 8 / 1 000 = **368 cas**. **b)** Total : 240 + 368 = 608 cas ; part du groupe à faible risque : 368 / 608 = 0,605, soit **60,5 %**. **c)** Même si le risque individuel est 7,5 fois plus élevé dans le groupe IMC ≥ 35 (60 / 8 = 7,5), la majorité des cas vient du groupe le plus nombreux : il faut associer une **stratégie populationnelle** (environnement, éducation pour tous) à la **stratégie à haut risque** (repérage, prise en charge).

À vous de jouer – Exercice 7 – Calculer un taux EGalim et proposer des ajustements

Un restaurant d'entreprise achète 200 000 € HT de denrées par an : bio 30 000 € ; Label Rouge et AOP/IGP 40 000 € ; produits « local mais conventionnel » 25 000 €. Les viandes et poissons représentent 60 000 € dont 30 000 € sous signe de qualité. a) Calculez les taux bio et « durables et de qualité ». b) Le taux pour les viandes et poissons. c) Respect de la loi ? d) Combien faudrait-il réorienter d'achats bio pour atteindre 20 % ?

Corrigé

a) Bio : 30 000 / 200 000 × 100 = **15 %**. Durables et de qualité : (30 000 + 40 000) / 200 000 × 100 = **35 %** (le « local conventionnel » ne compte pas : le local n'est pas un critère EGalim en soi). **b)** Viandes et poissons : 30 000 / 60 000 × 100 = **50 %**. **c)** Non respect : 15 % < 20 % (bio) ; 35 % < 50 % ; 50 % < 60 % (viandes et poissons, obligation depuis le 1er janvier 2024 ; la restauration collective privée est concernée depuis 2024). **d)** Objectif bio : 20 % × 200 000 = 40 000 € ; il faut **10 000 €** d'achats bio supplémentaires (à budget constant, par réorientation d'achats conventionnels).

À vous de jouer – Exercice 8 – Coût d'une recette mise à l'échelle

Une recette de « dahl de lentilles » pour 6 personnes utilise : 300 g de lentilles corail (3,20 €/kg), 400 g de tomates concassées en conserve (2,10 €/kg), 200 mL de lait de coco (4,50 €/L), 150 g d'oignons (1,80 €/kg), 10 g d'épices (25 €/kg), 300 g de riz (1,90 €/kg). Calculez le coût pour 15 personnes et le coût par portion. Vous pouvez vérifier avec la feuille 1 du tableur.

Corrigé

Coefficient = 15 / 6 = **2,5**. Quantités pour 15 : lentilles 750 g ; tomates 1 000 g ; lait de coco 500 mL ; oignons 375 g ; épices 25 g ; riz 750 g. Coûts : lentilles 750 / 1 000 × 3,20 = 2,40 € ; tomates 1 000 / 1 000 × 2,10 = 2,10 € ; lait de coco 0,5 × 4,50 = 2,25 € ; oignons 0,375 × 1,80 = 0,675 € ; épices 0,025 × 25 = 0,625 € ; riz 0,75 × 1,90 = 1,425 €. **Total** = 2,40 + 2,10 + 2,25 + 0,675 + 0,625 + 1,425 = **9,475 € ≈ 9,48 €** pour 15 personnes. **Coût par portion** = 9,475 / 15 = **0,63 €**. Interprétation : un plat complet à base de légumineuses et de céréales coûte moins de 1 € par portion ; le lait de coco est l'ingrédient le plus coûteux (24 % du total : 2,25 / 9,475) et peut être remplacé en partie par du lait ou du yaourt.

À vous de jouer – Exercice 9 – Rédiger des objectifs SMART

Réécrivez ces objectifs pour qu'ils soient SMART : a) « Améliorer l'alimentation des collégiens. » b) « Faire des ateliers sur le petit-déjeuner. » c) « Que les personnes âgées mangent mieux. »

Corrigé

a) Objectif spécifique : « D'ici juin 2028, la proportion d'élèves de 6e du collège Jean-Moulin qui déclarent prendre un petit-déjeuner au moins 5 jours sur 7 passe de 62 % à 75 %. » **b)** Objectif opérationnel : « Animer, entre janvier et mars 2028, 4 ateliers petit-déjeuner d'une heure dans chacune des 5 classes de 6e, avec au moins 90 % des élèves présents. » **c)** Objectif spécifique : « D'ici décembre 2028, 80 % des résidents de la résidence autonomie Les Lilas bénéficient d'une pesée mensuelle et 100 % des résidents ayant perdu 5 % de leur poids en un mois sont orientés vers le médecin traitant. » Chaque objectif comporte un public précis, un indicateur chiffré avec une valeur de départ quand elle est connue, une échéance, et reste réaliste au regard des moyens.

À vous de jouer – Exercice 10 – Tableau de bord

Un projet prévoyait 8 séances, 15 participants par séance, 85 % de satisfaits et un budget de 2 400 €. Réalisé : 7 séances, 94 présences cumulées, 26 satisfaits sur 30 répondants, 2 280 € dépensés. Calculez les taux d'atteinte et concluez.

Corrigé

- Séances : 7 / 8 × 100 = **87,5 %** (partiellement atteint).
- Présences : prévu 8 × 15 = 120 ; 94 / 120 × 100 = **78,3 %** (non atteint, < 80 %). Présence moyenne réelle par séance réalisée : 94 / 7 = 13,4 participants.
- Satisfaction : 26 / 30 = **86,7 %** ; taux d'atteinte 86,7 / 85 × 100 = **102 %** (atteint).
- Budget : 2 280 / 2 400 × 100 = **95 %** (dans le budget ; 120 € non dépensés, cohérent avec la séance annulée).
- **Conclusion** : le projet satisfait les participants mais la participation est insuffisante ; analyser les causes (horaires, communication, séance annulée) et proposer des ajustements (rappels, horaires, implication de relais).

À vous de jouer – Exercice 11 – Interpréter des chiffres

Expliquez pourquoi on ne peut pas conclure que l'obésité a augmenté de 1,1 point entre 2015 (17 %, ESTEBAN) et 2024 (18,1 %, OFÉO).

Corrigé

Les deux études diffèrent par la **méthode** (mesures réalisées par un enquêteur dans ESTEBAN ; poids et taille **déclarés** dans OFÉO, qui ont tendance à sous-estimer l'IMC), par la **population** (18-74 ans pour ESTEBAN ; adultes y compris personnes âgées et outre-mer pour OFÉO) et par l'**échantillonnage**. Une comparaison dans le temps exige la même méthode : c'est l'intérêt des enquêtes répétées comme Albane. On peut seulement dire que l'ordre de grandeur reste d'environ **un adulte sur six**.

1.8.3 Questions de réflexion

À vous de jouer – Question 1

Pourquoi une action d'éducation nutritionnelle « pour tous » peut-elle augmenter les inégalités sociales de santé ? Comment l'éviter ?

Corrigé

Les personnes les plus favorisées ont plus de **ressources** (temps, argent, littératie, réseau) pour s'approprier les messages et changer leurs pratiques : l'écart avec les plus défavorisés peut donc **s'accroître** (effet « Matthieu »). Pour l'éviter : appliquer l'**universalisme proportionné** (renforcer l'action là où les besoins sont plus importants), adapter les supports à la **littératie** (FALC, pictogrammes, langues), agir sur les **déterminants structurels** (prix, offre, cantine à tarification sociale) et impliquer les personnes concernées dans la conception (**participation**).

À vous de jouer – Question 2

Un industriel propose de financer vos ateliers en échange de la distribution de ses céréales du petit-déjeuner. Que faites-vous ?

Corrigé

Il s'agit d'un **conflit d'intérêts** : le diététicien doit délivrer une information **indépendante** et ne pas faire la promotion d'une marque (chapitre 6). On refuse la distribution de produits de marque et la présence du logo sur les supports pédagogiques ; on peut rechercher d'autres financements (ARS, collectivités, fondations sans lien avec les produits concernés) ou, si un partenariat privé est envisagé, l'encadrer par une **convention** garantissant l'indépendance du contenu, conformément aux règles de la structure. On en informe la tutrice et on le mentionne dans le dossier (règles éthiques et déontologiques respectées, C3.1).

À vous de jouer – Question 3

« La santé publique, c'est convaincre les gens de changer leurs comportements. » Discutez cette affirmation.

Corrigé

L'affirmation est **réductrice**. Les comportements sont influencés par de nombreux **déterminants** (Dahlgren et Whitehead) : revenus, offre alimentaire, culture, conditions de travail. La Charte d'Ottawa montre que la santé publique agit aussi sur les **politiques**, les **milieux de vie**, la **communauté** et les **services**, et pas seulement sur les aptitudes individuelles. Une approche uniquement persuasive risque de **culpabiliser** et d'être peu efficace. Toutefois, l'éducation pour la santé reste un levier important lorsqu'elle est **participative** et développe les **compétences** (auto-efficacité). Conclusion : la santé publique combine actions sur l'environnement et développement du pouvoir d'agir.

À vous de jouer – Question 4

En quoi l'approche « Une seule santé » change-t-elle le contenu d'un atelier culinaire ?

Corrigé

L'atelier intègre, en plus de l'équilibre nutritionnel, des critères **environnementaux** (produits de saison, végétalisation, légumineuses, limitation du gaspillage, tri des déchets, énergie) et parfois **animaux** (origine et mode d'élevage des produits animaux). Les messages montrent les **co-bénéfices** (« bon pour moi, bon pour la planète, bon pour le budget ») sans culpabiliser, et l'évaluation peut inclure des indicateurs environnementaux (part de produits de saison, quantité de déchets). C'est l'esprit de la SNANC et des gestes éco-responsables exigés par le référentiel (C3.2).

1.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – La commune de Saint-Aubin (12 000 habitants)

La commune rurale de Saint-Aubin vous recrute pour un mois afin de préparer un projet sur l'alimentation des personnes âgées vivant à domicile. Documents : 26 % des habitants ont 65 ans ou plus ; 180 bénéficiaires du portage de repas du CCAS ; 1 supermarché à 8 km, pas de transport en commun ; un club des aînés (60 adhérents) ; une maison de santé pluriprofessionnelle ; 4 hospitalisations pour dénutrition signalées par la MSP l'an dernier. Le CLS de la communauté de communes comporte un axe « bien vieillir ».

1. Identifiez le problème de santé, la population, et justifiez qu'il s'agit d'un problème de santé publique.
2. Quels modes d'intervention et niveaux de prévention pouvez-vous mobiliser ? Donnez un exemple d'action pour chacun.
3. Citez les acteurs et les politiques sur lesquels vous appuyer.
4. Proposez un objectif général, deux objectifs spécifiques SMART et deux indicateurs d'évaluation.
5. Quelles précautions éthiques prenez-vous ?

Corrigé

1. Problème : risque de **dénutrition** des personnes âgées vivant à domicile. **Population** : 65 ans et plus (26 % de 12 000 = **3 120 personnes**), en particulier les 180 bénéficiaires du portage (fragilité). C'est un problème de santé publique car il est **fréquent** (la dénutrition concerne une part importante des personnes âgées, notamment à domicile et en établissement), **grave** (chutes, infections, hospitalisations, mortalité), **coûteux**, **évitable** et socialement inégalitaire (isolement, revenus, ruralité, absence de transport), et une **priorité** du PNNS 5 (prévention de la dénutrition) et du CLS (axe « bien vieillir »).

2. Promotion de la santé : plaider pour un transport à la demande vers le supermarché ou un marché itinérant ; repas partagés au club des aînés (milieu favorable, lien social). **Prévention primaire** : ateliers « bien manger après 70 ans » au club (éducation alimentaire) ; enrichissement des repas portés. **Prévention secondaire** : repérage (pesée mensuelle, questionnaire) par les livreurs de repas formés et la MSP, orientation vers le médecin. **Prévention tertiaire** : prise en charge diététique des personnes dénutries (BC1). **Prévention quaternaire** : éviter les régimes restrictifs inutiles après 75 ans (par exemple, régime sans sel strict non justifié).

3. Acteurs : CCAS (portage), MSP et médecins traitants, club des aînés, conseil départemental (APA), ARS (CLS, appels à projets), caisses de retraite (actions de prévention), associations d'aide à domicile. **Politiques** : PNNS 5, PRS (axe vieillissement), CLS « bien vieillir », recommandations HAS/FFAMCO 2021 sur le diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus.

4. Objectif général : contribuer à prévenir la dénutrition des personnes âgées vivant à domicile à Saint-Aubin d'ici 2028. **Objectif spécifique 1** : d'ici juin 2028, 100 % des bénéficiaires du portage de repas sont pesés au moins une fois par mois et toute perte de poids ≥ 5 % en un mois est signalée au médecin traitant. **Objectif spécifique 2** : d'ici juin 2028, 70 % des participants aux ateliers déclarent consommer au moins 3 produits laitiers par jour (repère personnes âgées) contre une valeur initiale mesurée au premier atelier. **Indicateurs** : proportion de bénéficiaires pesés mensuellement (processus) ; nombre d'orientations vers le médecin (processus) ; proportion de participants atteignant le repère produits laitiers (résultat).

5. Éthique : consentement des personnes pour la pesée et la transmission d'informations au médecin ; **secret professionnel** et **RGPD** (données de santé = données sensibles) ; respect de l'autonomie (pas d'imposition) ; non-stigmatisation (ne pas parler de « vieux dénutris ») ; attention aux personnes isolées ou atteintes de troubles cognitifs (associer l'aidant).

1.8.5 Mises en situation express

Répondez en 3 à 5 lignes, comme à l'entretien de l'épreuve E5.

Mise en situation – MSE 1

Le jury vous demande : « Votre projet, c'est de la prévention ou de la promotion de la santé ? » (projet d'ateliers cuisine dans un centre social).

Corrigé

C'est d'abord une action d'**éducation pour la santé** (alimentaire et nutritionnelle) au service de la **prévention primaire sélective** (public exposé à un risque du fait de la précarité). Elle s'inscrit dans une **démarche de promotion de la santé** dans la mesure où les familles ont participé au choix des thèmes (pouvoir d'agir), où un partenariat avec l'épicerie solidaire améliore l'accès aux produits (milieu favorable) et où le projet s'inscrit dans le CLS (politique locale).

Mise en situation – MSE 2

Une animatrice vous dit : « Le PNNS 4, c'est bien ce qui est en vigueur ? »

Corrigé

Non : le PNNS 4 couvrait 2019-2023. Depuis le **8 avril 2026**, c'est le **PNNS 5 (2026-2030)**, déclinaison de la **SNANC 2025-2030** publiée le 11 février 2026. Je lui propose une courte note de veille avec les sources (ministère de la Santé, mangerbouger.fr) et je mets à jour nos supports.

Mise en situation – MSE 3

Dans une école, un enseignant veut peser tous les élèves en classe pour « sensibiliser ».

Corrigé

Je déconseille la pesée collective : elle est **stigmatisante**, sans intérêt éducatif et pose un problème de **confidentialité** des données de santé. Le repérage relève du service de santé scolaire, en individuel. Je propose plutôt une action universelle (éducation sensorielle, goûters, activité physique) et un travail avec les parents.

Mise en situation – MSE 4

Une mère dit lors d'un atelier : « De toute façon, chez nous on mange du riz tous les jours, c'est notre culture. »

Corrigé

J'accueille cette remarque sans jugement (posture de **respect culturel**) et je valorise ce qui est favorable (le riz est un féculent, base de repas) ; je propose de **partir de ses recettes** (par exemple, riz associé à des légumes secs et des légumes : plats complets du monde) plutôt que de lui imposer un modèle ; la recette peut être intégrée au livret (atelier « recettes du monde »).

Mise en situation – MSE 5

Vous voulez utiliser des photos de l'atelier pour le livret et le compte du centre social sur un réseau social.

Corrigé

Il faut une **autorisation écrite** de chaque personne photographiée (et des deux titulaires de l'autorité parentale pour un mineur), précisant les supports, la durée et la finalité (**droit à l'image** et RGPD) ; possibilité de refuser ou de retirer son accord ; photos sans visage (mains, plats) pour ceux qui refusent ; pas de noms de famille.

Mise en situation – MSE 6

L'ARS demande un indicateur de résultat pour votre projet d'ateliers.

Corrigé

Un indicateur de **résultat** mesure un effet sur le public : par exemple, « proportion de participants déclarant consommer des légumes secs au moins 2 fois par semaine, avant et après le cycle » (25 % → 75 % dans le fil rouge). Le nombre d'ateliers ou de participants est un indicateur de **processus**.

Mise en situation – MSE 7

Le directeur d'un EHPAD vous demande une « action de santé publique » sur la dénutrition.

Corrigé

Je précise d'abord le besoin par un **diagnostic** (prévalence de la dénutrition selon les critères HAS/FFAMCO 2021, pesées, organisation des repas, avis des résidents et des soignants). L'action peut associer prévention secondaire (dépistage systématique), primaire (repas enrichis, convivialité, textures adaptées, collations) et formation des soignants (BC2) ; elle s'inscrit dans le PNNS 5 (dénutrition) et les recommandations de la HAS.

Mise en situation – MSE 8

Quelle différence entre surveillance et veille sanitaire ?

Corrigé

La **surveillance** est une collecte **continue et systématique** de données pour décrire et suivre l'état de santé (par exemple, enquêtes INCA, ESTEBAN, Albane). La **veille** vise à **détecter des signaux** inhabituels (TIAC, alerte sur un produit) pour **alerter** rapidement les autorités. En France, Santé publique France assure les deux missions.

Mise en situation – MSE 9

Le jury : « Pourquoi parlez-vous d'universalisme proportionné dans votre projet ? »

Corrigé

Parce que le projet propose des actions ouvertes à toutes les familles du quartier (universel) mais renforcées pour les familles de l'épicerie solidaire (gratuité, transport pour la visite du marché, rappels personnalisés, supports traduits) : l'intensité de l'action est **proportionnelle au désavantage**, pour ne pas creuser les inégalités tout en évitant la stigmatisation.

Mise en situation – MSE 10

Un participant à votre atelier vous annonce qu'il est diabétique et vous demande un régime.

Corrigé

L'atelier est une action d'éducation pour la santé collective : je ne prescris pas de régime individuel. Je l'oriente vers son **médecin traitant** et une **consultation diététique** ou un **programme d'ETP** (BC1). Je m'assure que les recettes de l'atelier lui conviennent (pas de contre-indication) et je respecte la confidentialité de son information devant le groupe.

Mise en situation – MSE 11

Où trouvez-vous des données sur l'état de santé de la population de votre lieu de stage ?

Corrigé

Insee (démographie, pauvreté par commune ou par QPV), **Géodes** (Santé publique France), ORS (portraits de territoire, Score-santé), ARS (diagnostic du PRS et du CLS), Drees, CPAM (données de l'Assurance maladie, ALD), service de santé scolaire et PMI (avec leur accord, données agrégées). Je **date** et **source** chaque donnée.

Mise en situation – MSE 12

Votre tutrice vous demande d'envoyer la liste des participants (nom, adresse, allergies) à l'épicerie partenaire par messagerie personnelle.

Corrigé

Les allergies sont des **données de santé** (données sensibles, RGPD). Je ne transmets que les données **strictement nécessaires** et avec l'**accord** des personnes ; j'utilise la messagerie professionnelle de la structure (pas ma messagerie personnelle), un fichier protégé si nécessaire, et je n'envoie pas de données de santé sans finalité justifiée (compétences C3.5 et C3.6 ; chapitres 20 et 21).

Mise en situation – MSE 13

Comment montrez-vous que votre atelier intègre des gestes éco-responsables ?

Corrigé

Choix de produits de **saison** et **locaux** (60,9 % du coût dans l'atelier n° 3), produits en vrac, plat **végétal** principal (légumineuses), compostage des épluchures au jardin partagé, four rempli, restes emportés dans des boîtes réutilisables, pas de vaisselle jetable, consommation d'eau et d'énergie maîtrisée ; j'en fais un indicateur (part de produits de saison, quantité de déchets).

Mise en situation – MSE 14

Une famille allophone ne comprend pas le flyer.

Corrigé

Je tiens compte de la **littératie** et de la **langue** : flyer illustré avec pictogrammes et photos, traduction dans les langues les plus parlées (avec des habitants relais ou un service d'interprétariat), invitation **orale** par une personne de confiance (animatrice, médiatrice), et animation de l'atelier par le geste et la démonstration (chapitre 5).

1.9 Glossaire

Terme	Définition
Action communautaire	Action dans laquelle les membres d'une communauté (quartier, groupe) participent à l'identification des problèmes, aux décisions et à la mise en œuvre ; domaine 3 de la Charte d'Ottawa
Agence régionale de santé (ARS)	Établissement public créé par la loi HPST (2009) qui pilote la politique de santé en région (PRS, financement de la prévention, appels à projets, CLS)
Appel à projets (AAP)	Procédure par laquelle un financeur (ARS, DRAAF, fondation) définit un cahier des charges et sélectionne des projets à financer
Approche populationnelle	Approche qui vise l'ensemble d'une population pour déplacer la distribution d'un facteur de risque (Rose)
Contrat local de santé (CLS)	Contrat entre l'ARS et une collectivité pour mettre en œuvre le PRS localement
Danger	Propriété intrinsèque d'un agent ou d'une situation capable de provoquer un effet néfaste
Déterminant de santé	Facteur personnel, social, économique ou environnemental qui influence l'état de santé
Éducation pour la santé	Démarche qui vise à ce que chacun acquière les compétences et les moyens de promouvoir sa santé ; nutritionnelle, alimentaire, sensorielle
Éducation thérapeutique du patient (ETP)	Démarche de soin visant à aider les patients atteints de maladie chronique à acquérir des compétences pour gérer leur maladie (art. L. 1161-1 CSP) ; relève du BC1
EGalim	Loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine, durable et accessible à tous
Empowerment (pouvoir d'agir)	Processus par lequel une personne ou un groupe acquiert la capacité de contrôler les décisions qui concernent sa santé
Facteur de protection	Caractéristique associée à une diminution de la probabilité de maladie
Facteur de risque	Caractéristique ou exposition associée à une augmentation de la probabilité de maladie
Gradient social de santé	Dégradation progressive de l'état de santé à chaque échelon de l'échelle sociale
Incidence	Nombre de nouveaux cas d'une maladie survenus pendant une période dans une population à risque
Indicateur de processus	Indicateur qui mesure la réalisation des activités et des moyens (nombre de séances, de participants, budget)
Indicateur de résultat	Indicateur qui mesure les effets sur le public (connaissances, comportements, état de santé)

Terme	Définition
Inégalités sociales de santé	Différences systématiques, évitables et injustes d'état de santé entre groupes sociaux
Marketing social	Application des techniques du marketing à la promotion de comportements favorables à la santé
Nudge	Modification de l'architecture du choix qui oriente les comportements sans interdiction ni incitation financière
Nutri-Score	Logo nutritionnel facultatif à 5 classes (A à E) ; nouvel algorithme applicable par arrêté du 14 mars 2025
One Health (Une seule santé)	Approche intégrée qui vise à équilibrer et optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes
Paradoxe de la prévention	Constat de Rose (1985) : une mesure bénéfique à la population apporte peu à chaque individu ; la majorité des cas provient de la population à risque modéré
PNA	Programme national pour l'alimentation (ministère de l'Agriculture) ; PNA 4 : 2026-2030
PNNS	Programme national nutrition santé (ministère de la Santé), depuis 2001 ; PNNS 5 : 2026-2030
Prévalence	Nombre (ou proportion) de cas existants d'une maladie dans une population à un moment donné
Prévention primaire / secondaire / tertiaire	Classification de l'OMS (1948) : avant la maladie (incidence) / au début (prévalence, dépistage) / maladie installée (complications)
Prévention quaternaire	Prévention de la surmédicalisation (Jamoulle, 1986)
Prévention universelle / sélective / indiquée	Classification de Gordon (1983) selon le public : tous / groupe à risque / personnes présentant des facteurs de risque
Projet alimentaire territorial (PAT)	Démarche collective territoriale pour une alimentation locale, durable et accessible (loi du 13 octobre 2014)
Projet régional de santé (PRS)	Document de l'ARS : COS (10 ans), SRS (5 ans), PRAPS
Promotion de la santé	Processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci (Ottawa, 1986)
QPV	Quartier prioritaire de la politique de la ville, défini par un critère de revenu des habitants
Risque	Probabilité de survenue d'un effet néfaste, fonction du danger et de l'exposition
Santé (OMS)	État de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité (1946)
Santé publique	Ensemble des savoirs et actions organisées et collectives visant à maintenir et améliorer la santé de la population
SMART	Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel : critères de formulation des objectifs
SNANC	Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat 2025-2030 (loi Climat et résilience, art. 265), publiée le 11 février 2026
Surveillance épidémiologique	Collecte systématique et continue, analyse, interprétation et diffusion de données de santé pour orienter l'action
Universalisme proportionné	Actions universelles dont l'intensité est proportionnelle au niveau de désavantage (Marmot, 2010)

Terme	Définition
Veille sanitaire	Détection et évaluation des signaux sanitaires pour alerter les autorités

1.10 Renvois bibliographiques par notion

Les numéros renvoient à la bibliographie numérotée (partie 1.12).

Notion	Références
Définition de la santé, One Health	[1] Constitution de l'OMS ; [3] Charte d'Ottawa ; [5] OHHLEP/Quadripartite ; [6] Huber et coll. ; [21] guide d'accompagnement du BTS
Santé publique, missions	[2] Winslow ; [7] Code de la santé publique art. L. 1411-1 ; [8] loi du 26 janvier 2016 ; [33] Bonita et coll. (OMS)
Paradoxe de la prévention	[9] Rose, 1985
Promotion de la santé	[3] Charte d'Ottawa ; [4] chartes et déclarations ultérieures ; [10] Dahlgren et Whitehead ; [11] Marmot, 2010 ; [32] AFDN, guide santé publique
Prévention	[12] Gordon, 1983 ; [13] Jamoulle ; [14] San Marco
Éducation pour la santé, CPS	[15] Plan national d'éducation pour la santé, 2001 ; [16] Santé publique France, référentiel CPS, 2022
Surveillance, données	[17] Santé publique France, ESTEBAN ; [18] ANSES, INCA 3 ; [19] Albane ; [20] OFÉO ; [26] Insee ; [27] Crédoc
Politiques nutritionnelles	[22] SNANC 2025-2030 ; [23] PNNS 5 ; [24] PNA 4 ; [25] HCSP, avis 2025 ; [28] loi EGalim ; [29] arrêté Nutri-Score 2025 ; [30] repères Santé publique France 2019 ; [31] HCSP, repères 2017
Organisation territoriale	[7] CSP (ARS, PRS, CLS) ; [34] loi HPST ; [35] loi d'avenir pour l'agriculture (PAT)
Diététicien en santé publique	[7] CSP art. L. 4371-1 ; [21] référentiel et guide du BTS ; [32] AFDN
Approfondissements et L3	[38] Sen ; [39] Swinburn et coll. ; [40] Pawson et Tilley ; [41] Monteiro (NOVA) ; [42] consensus sur la stigmatisation du poids ; [43] EAT-Lancet

1.12 Bibliographie numérotée

Liens consultés le 26 octobre 2026. Les textes réglementaires sont consultables sur legifrance.gouv.fr.

Textes fondateurs et définitions

1. Organisation mondiale de la santé. *Constitution de l'Organisation mondiale de la santé*. New York, 22 juillet 1946 (entrée en vigueur le 7 avril 1948). who.int/fr/about/governance/constitution
2. Winslow C.-E. A. « The untilled fields of public health ». *Science*, 1920, 51 (1306), p. 23-33.
3. Organisation mondiale de la santé. *Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé*. Première Conférence internationale pour la promotion de la santé, Ottawa, 21 novembre 1986.
4. Organisation mondiale de la santé. Déclarations d'Alma-Ata (1978), d'Adélaïde (1988 et 2010), de Jakarta (1997), Charte de Bangkok (2005), Déclaration d'Helsinki (2013), de Shanghai (2016), Charte de Genève pour le bien- être (2021).

5. One Health High-Level Expert Panel (OHHLEP), Adisasmito W. B. et coll. « One Health: A new definition for a sustainable and healthy future ». *PLoS Pathogens*, 2022, 18 (6) ; plan d'action conjoint One Health de la Quadripartite (FAO, PNUE, OMS, OMSA) 2022-2026.

6. Huber M. et coll. « How should we define health? » *BMJ*, 2011, 343:d4163.

7. *Code de la santé publique* : articles L. 1411-1 et L. 1411-1-1 (politique et stratégie nationale de santé), L. 1434-1 et suivants (PRS), L. 1434-10 (CLS), L. 1161-1 (ETP), L. 4371-1 et suivants (profession de diététicien).

8. Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

9. Rose G. « Sick individuals and sick populations ». *International Journal of Epidemiology*, 1985, 14 (1), p. 32-38.

10. Dahlgren G., Whitehead M. *Policies and strategies to promote social equity in health*. Stockholm, Institute for Futures Studies, 1991.

11. Marmot M. et coll. *Fair Society, Healthy Lives (The Marmot Review)*. Londres, 2010.

12. Gordon R. « An operational classification of disease prevention ». *Public Health Reports*, 1983, 98 (2), p. 107-109.

13. Jamoulle M. « Information et informatisation en médecine générale » (concept de prévention quaternaire), 1986 ; Jamoulle M. « Quaternary prevention, an answer of family doctors to overmedicalization ». *International Journal of Health Policy and Management*, 2015.

14. San Marco J.-L. « Définitions » de la prévention, in Bourdillon F., Brücker G., Tabuteau D. (dir.). *Traité de santé publique*. Paris, Flammarion Médecine-Sciences, 3e éd., 2016.

15. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité. *Plan national d'éducation pour la santé*. Paris, 2001.

16. Santé publique France. *Les compétences psychosociales : un référentiel pour un déploiement auprès des enfants et des jeunes*. Saint-Maurice, 2022.

Données et surveillance

17. Santé publique France. *Étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition (ESTEBAN), 2014-2016 – Volet nutrition – Chapitre corpulence*. 2017.

18. ANSES. *Troisième étude individuelle nationale des consommations alimentaires (INCA 3)*. Avis et rapport, juin 2017.

19. Santé publique France, ANSES. *Albane : enquête de santé, biosurveillance, environnement, alimentation et nutrition* – lancement du cycle 1, communiqué du 10 juin 2025. anses.fr

20. Ligue nationale contre l'obésité. *Étude OFÉO – Prévalence de l'obésité en France*. Dossier de presse, 20 juin 2024. liguecontrelobesite.org

Référentiel, guide et profession

21. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Diététique et nutrition », *JO* du 17 décembre 2024 ; *Guide d'accompagnement pédagogique du BTS Diététique et nutrition*, 29 avril 2025.

Politiques nutritionnelles

22. Gouvernement. *Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat 2025-2030 (SNANC)*. Publiée le 11 février 2026. ecologie.gouv.fr – SNANC 2025-2030

23. Ministère chargé de la Santé. *Programme national nutrition santé 2026-2030 (PNNS 5)*. Lancé le 8 avril 2026. Synthèses : Réseau national nutrition santé, reseau-national-nutrition-sante.fr ; Vidal, « Le cinquième programme national nutrition santé officiellement lancé », avril 2026.

24. Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. *Programme national pour l'alimentation 2026-2030 (PNA 4)*. Avril 2026. agriculture.gouv.fr

25. Haut Conseil de la santé publique. *Recommandations pour l'élaboration du 5e Programme national nutrition santé*. Juin 2025. hcsp.fr

26. Insee. *Bilan démographique 2025*. Insee Première n° 2087, janvier 2026 ; Blanpain N. « L'espérance de vie par niveau de vie », Insee Première n° 1687, février 2018.

27. Crédoc. *En forte hausse, la précarité alimentaire s'ajoute à d'autres fragilités*. Consommation et modes de vie, 2023.

28. Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGalim) ; loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; plateforme ma-cantine.agriculture.gouv.fr.

29. Arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle (Nutri-Score), modifié par l'arrêté du 14 mars 2025 ; sante.fr – le nouveau Nutri-Score.

30. Santé publique France. *Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes*. Janvier 2019 ; mangerbouger.fr.

31. Haut Conseil de la santé publique. *Avis relatif à la révision des repères alimentaires pour les adultes du futur PNNS 2017-2021*. Février 2017 ; *Avis relatif à la révision des repères alimentaires pour les enfants âgés de 0-36 mois et de 3-17 ans*. Juin 2020 ; ANSES. *Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires*. Décembre 2016.

Profession, organisation, approfondissements

32. Association française des diététiciens nutritionnistes (AFDN). *Le diététicien dans les actions de santé publique*. Version 2, 2022. afdn.org

33. Bonita R., Beaglehole R., Kjellström T. *Éléments d'épidémiologie*. 2e éd., Organisation mondiale de la santé, 2010.

34. Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST).

35. Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (projets alimentaires territoriaux).

36. Lalonde M. *Nouvelle perspective de la santé des Canadiens*. Ottawa, Gouvernement du Canada, 1974.

37. Commission des déterminants sociaux de la santé (OMS). *Combler le fossé en une génération*. Genève, OMS, 2008.

38. Sen A. *Repenser l'inégalité*. Paris, Seuil, 2000 ; Sen A. *Un nouveau modèle économique*. Paris, Odile Jacob, 2000.

39. Swinburn B. et coll. « The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change: The Lancet Commission report ». *The Lancet*, 2019, 393, p. 791-846.

40. Pawson R., Tilley N. *Realistic Evaluation*. Londres, Sage, 1997 ; Skivington K. et coll. « A new framework for developing and evaluating complex interventions ». *BMJ*, 2021, 374:n2061.

41. Monteiro C. A. et coll. « Ultra-processed foods: what they are and how to identify them ». *Public Health Nutrition*, 2019, 22 (5), p. 936-941.

42. Rubino F. et coll. « Joint international consensus statement for ending stigma of obesity ». *Nature Medicine*, 2020, 26, p. 485-497.

43. Willett W. et coll. « Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems ». *The Lancet*, 2019, 393, p. 447-492.

44. Thaler R., Sunstein C. *Nudge*. New Haven, Yale University Press, 2008.

45. Santé publique France. *Communiquer pour tous : guide pour une information accessible*. Ruel J., Allaire C. (dir.), 2018, mise à jour février 2025.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 1.2.2)

46. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

47. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE

01

CHAPITRE

01

La santé publique et la promotion de la santé en nutrition

Santé publique

Promotion de la santé

Politiques nutritionnelles

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

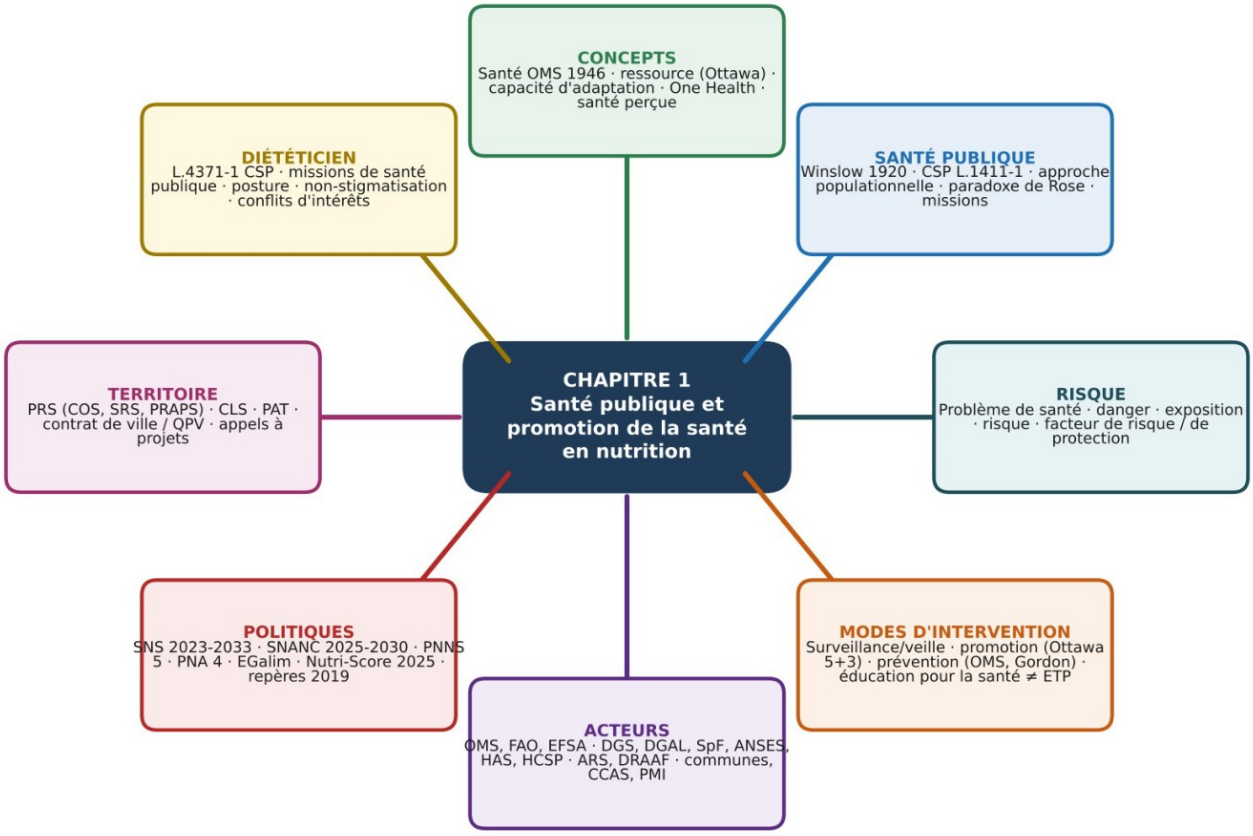
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 1 103
1. Les définitions à savoir par cœur 103
2. Les classifications à ne pas confondre 104
3. La Charte d'Ottawa : 5 + 3 104
4. Les dates et textes à jour (octobre 2026) 104
5. Chiffres-clés 105
6. Les pièges classiques 105
7. Méthode express pour l'oral E5 : qualifier son action en 4 phrases 105
8. Auto-test (réponses en bas de page) 105
9. Flashcards à découper 106

Fiches-outils du chapitre 1 106
O1.1 – Qualifier mon action 107
O1.2 – Portrait express de mon territoire 107
O1.3 – Carte des acteurs de mon territoire 108
O1.4 – Inscrire mon projet dans les politiques en vigueur 108
O1.5 – Analyser un projet avec la Charte d'Ottawa 109
O1.6 – Les déterminants de l'alimentation de mon public 109
O1.7 – Tableau de veille des politiques nutritionnelles 110
O1.8 – Check-list éthique et non-stigmatisation d'un message ou d'un support 110

Fiche de révision du chapitre 1

Santé publique, promotion de la santé et politiques nutritionnelles



Carte mentale du chapitre 1

1. Les définitions à savoir par cœur

Notion	Définition	Source, date
Santé	« État de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité »	OMS, Constitution, 1946
Santé (ressource)	« Ressource de la vie quotidienne, et non le but de la vie »	Charte d'Ottawa, 1986
One Health	Approche intégrée visant à équilibrer et optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes	OHHLEP / Quadripartite, 2021-2022
Santé publique	Science et art de prévenir les maladies, prolonger la vie et promouvoir la santé par les efforts coordonnés de la communauté	Winslow, 1920
Promotion de la santé	Processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci	Charte d'Ottawa, 21/11/1986

Notion	Définition	Source, date
Prévention	Ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps	OMS, 1948
Éducation pour la santé	Permettre à chacun d'acquérir les compétences et les moyens de promouvoir sa santé et celle de la collectivité	PNES, 2001
Universalisme proportionné	Actions pour tous, d'intensité proportionnelle au désavantage social	Marmot, 2010
Danger / risque	Danger = capacité à nuire ; risque = probabilité de l'effet néfaste (danger × exposition)	–

2. Les classifications à ne pas confondre

Prévention OMS (moment)	Indicateur visé	Gordon (public)	Exemple
Primaire : avant la maladie	Incidence	Universelle : tous	Repères PNNS, atelier cuisine pour tous
Secondaire : début, dépistage	Prévalence	Sélective : groupe à risque	Ateliers en QPV ; dépistage de la dénutrition
Tertiaire : maladie installée	Complications, récidives	Indiquée : facteurs de risque présents	ETP diabète (BC1) ; programme enfants en surpoids
Quaternaire (Jamoulle)	Surmédicalisation	–	Éviter les régimes inutiles

Patients atteints de maladie Déterminants, milieux, Compétences des personnes Un problème de santé défini chronique, programme déclaré politiques, pouvoir d'agir bien portantes à l'ARS

3. La Charte d'Ottawa : 5 + 3

- **5 domaines** : politique publique saine – milieux favorables – action communautaire – aptitudes individuelles
- réorientation des services de santé (« **P**our **M**anger **C**orrectement, **A**gissons **R**apidement »).
- **3 stratégies** : plaider – conférer les moyens – servir de médiateur.

4. Les dates et textes à jour (octobre 2026)

Date	Texte
1946 / 1948	Constitution de l'OMS (signée / entrée en vigueur)
1986	Charte d'Ottawa
2001	PNNS 1
2004	Loi relative à la politique de santé publique (PNNS dans la loi, distributeurs interdits à l'école)
2009	Loi HPST (ARS, ETP)
2014	Loi d'avenir pour l'agriculture (PAT)
2016	Loi de modernisation de notre système de santé (Nutri-Score, 2017)
2018	Loi EGalim (50 % durables et de qualité dont 20 % bio)
2019	Repères alimentaires Santé publique France ; PNNS 4 (2019-2023)
2021	Loi Climat et résilience (art. 265 : SNANC)
14/03/2025	Nouvel algorithme du Nutri-Score (arrêté)

Date	Texte
Juin 2025	Avis du HCSP pour le PNNS 5 ; lancement de l'enquête Albane
11/02/2026	SNANC 2025-2030 publiée
08/04/2026	PNNS 5 et PNA 4 (2026-2030) lancés (One Health Summit, Lyon)

5. Chiffres-clés

- Obésité de l'adulte : **18,1 %** (OFÉO 2024) ; 22,4 % outre-mer ; 24,7 % en cas de difficultés économiques.
- Surpoids des 6-17 ans : **17 %** dont 4 % d'obésité (ESTEBAN 2015).
- Précarité alimentaire : **16 %** (Crédoc 2022).
- 5 fruits et légumes/jour : **30 %** des adultes, 20 % des enfants ; fibres < 25 g/j : 90 % des adultes (HCSP 2025).
- Espérance de vie 2025 : **85,9 ans** (F), **80,3 ans** (H) ; écart de ≈ 13 ans entre hommes aisés et modestes.
- PNNS 5 : **3 axes, 20 mesures**, – 30 % de surpoids et d'obésité chez les enfants et adolescents (– 20 % chez les plus défavorisés).
- EGalim (achats 2023) : ≈ 25,5 % durables et de qualité, 12,1 % bio.

6. Les pièges classiques

Attention

- Citer le **PNNS 4** comme en vigueur → c'est le **PNNS 5 (2026-2030)**.
- Dire que le **Nutri-Score est obligatoire** → il est **facultatif**.
- Classer le **dépistage** en prévention primaire → **secondaire**.
- Appeler « éducation pour la santé » un atelier destiné à des **patients** d'un programme d'ETP → c'est de l'**ETP** (BC1).
- Confondre **incidence** (nouveaux cas) et **prévalence** (cas existants).
- Comparer des chiffres issus de **méthodes différentes** (mesuré / déclaré).
- Oublier les **déterminants** et proposer uniquement de l'information.

7. Méthode express pour l'oral E5 : qualifier son action en 4 phrases

1. Mode d'intervention : « Mon projet est une action d'éducation pour la santé (alimentaire/nutritionnelle/sensorielle)… »

2. Prévention : « … au service de la prévention primaire, sélective, car le public… »

3. Promotion de la santé : « Il s'inscrit dans une démarche de promotion de la santé car… (participation, milieu favorable, partenariat). »

4. Politiques : « Il répond à l'axe … du PNNS 5 (2026-2030), à l'objectif … du PRS et à la fiche-action … du CLS. »

8. Auto-test (réponses en bas de page)

1. Qui a défini la santé publique en 1920 ?
2. Quels sont les 5 domaines d'action de la Charte d'Ottawa ?
3. Quel niveau de prévention fait baisser l'incidence ?
4. Quelle classification distingue universelle, sélective et indiquée ?
5. Quelle loi prévoit la SNANC ? Quand a-t-elle été publiée ?
6. Combien d'axes et d'actions compte le PNNS 5 ?
7. Quels sont les deux seuils EGalim en restauration collective ?
8. Quel organisme conduit les études INCA ? Et ESTEBAN ?

9. Que contient un PRS ?

10. Calculez le coût par portion d'une recette de 9,60 € pour 12 portions.

11. Une diététicienne anime un atelier pour des patients d'un programme ETP diabète : de quoi s'agit-il ?

12. Donnez la formule du taux d'atteinte d'un indicateur. *Réponses : 1. Winslow – 2. Politique publique saine, milieux favorables, action communautaire, aptitudes individuelles, réorientation des services – 3. Primaire – 4. Gordon (1983) – 5. Loi Climat et résilience (art. 265) ; 11 février 2026 – 6. 3 axes, 20 mesures – 7. 50 % de produits durables et de qualité dont 20 % de bio (et 60 % pour*

viandes et poissons) – 8. ANSES ; Santé publique France – 9. COS (10 ans), SRS (5 ans), PRAPS – 10. 9,60 / 12 = 0,80 €

- *– 11. ETP, prévention tertiaire (BC1) – 12. Réalisé / prévu × 100.*

9. Flashcards à découper

Recto : Charte d'Ottawa – date et 3 stratégies ?	Verso : 21 novembre 1986 ; plaider, conférer les moyens, servir de médiateur
Recto : Prévalence ou incidence : laquelle baisse avec la prévention primaire ?	Verso : L'incidence (nouveaux cas)
Recto : Universalisme proportionné : auteur, date, principe ?	Verso : Marmot, 2010 ; pour tous, avec une intensité proportionnelle au désavantage
Recto : PNNS en vigueur et son objectif enfant ?	Verso : PNNS 5 (2026-2030) ; − 30 % de surpoids et d'obésité chez les enfants et adolescents
Recto : Que signifie SMART ?	Verso : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel
Recto : Rôle de l'ARS en prévention ?	Verso : PRS, financement (FIR), appels à projets, CLS, déclaration des programmes d'ETP
Recto : Paradoxe de Rose ?	Verso : Beaucoup de personnes à faible risque produisent plus de cas que peu de personnes à haut risque
Recto : Les 3 formes d'éducation pour la santé du guide BTS ?	Verso : Nutritionnelle, alimentaire, sensorielle

Fiches-outils du chapitre 1

Ces 8 outils complètent les fiches F1 à F14 pour les notions propres au chapitre 1. Ils sont vierges, à imprimer ou à remplir dans Word, et servent en stage (période 1 surtout), en préparation du dossier E5 et en révision.

Outil	Intitulé	Utilité
O1.1	Qualifier mon action	Nommer précisément le mode d'intervention et le niveau de prévention (oral E5)
O1.2	Portrait express de mon territoire	Collecter les données de base du diagnostic (F1)
O1.3	Carte des acteurs de mon territoire	Identifier partenaires, financeurs, ressources
O1.4	Inscrire mon projet dans les politiques en vigueur	Rédiger la partie « contexte » du dossier
O1.5	Analyser un projet avec la Charte d'Ottawa	Vérifier que le projet ne se limite pas à l'information
O1.6	Les déterminants de l'alimentation de mon public	Appliquer le modèle de Dahlgren et Whitehead
O1.7	Tableau de veille des politiques nutritionnelles	Tenir à jour les versions des textes (C3.4)
O1.8	Check-list éthique et non-stigmatisation d'un message	Contrôler un support avant diffusion

O1.1 – Qualifier mon action

Intitulé de l'action

Public (qui, combien, caractéristiques)

Problème de santé visé

Question	☐	Justification
Mode : surveillance / veille sanitaire	☐	
Mode : promotion de la santé (agit sur déterminants, milieux, politiques, pouvoir d'agir)	☐	
Mode : prévention (problème défini)	☐	
Mode : éducation pour la santé – nutritionnelle	☐	
Mode : éducation pour la santé – alimentaire	☐	
Mode : éducation pour la santé – sensorielle	☐	
Attention : s'agit-il d'ETP (patients, programme déclaré à l'ARS) ? → BC1	☐	
OMS : primaire (incidence)	☐	
OMS : secondaire (dépistage, prévalence)	☐	
OMS : tertiaire (complications)	☐	
OMS : quaternaire (surmédicalisation)	☐	
Gordon : universelle	☐	
Gordon : sélective	☐	
Gordon : indiquée	☐	
Approche : informative / persuasive / participative	☐	
Universalisme proportionné appliqué ?	☐	

Ma phrase de qualification pour l'oral (4 phrases : mode, prévention, promotion, politiques)

O1.2 – Portrait express de mon territoire

> **Consigne**
> Pour chaque indicateur, notez la valeur pour votre territoire et une valeur de comparaison (département, région ou France), avec la source et l'année. Sources utiles : Insee (statistiques locales), Géodes (Santé publique France), ORS (Score-santé), ARS (diagnostic du PRS, CLS), *sig.ville.gouv.fr* (QPV), Drees.

Indicateur	Mon territoire	Comparaison	Source	Année
Population totale				
Part des moins de 20 ans / des 65 ans et plus				
Familles monoparentales (%)				
Taux de pauvreté (%)				
Taux de chômage (%)				
Quartier prioritaire (oui/non, nom)				
Espérance de vie / mortalité prématurée				
Surpoids, obésité (enfants, adultes)				

Indicateur	Mon territoire	Comparaison	Source	Année
Diabète traité, maladies cardiovasculaires (ALD)				
Offre alimentaire (commerces, marché, restauration rapide)				
Restauration scolaire (tarification, EGalim)				
Aide alimentaire (épicerie, banque alimentaire)				
Équipements sportifs, espaces verts				
Professionnels de santé (MSP, diététiciens, PMI)				

Trois constats principaux

O1.3 – Carte des acteurs de mon territoire

Niveau	Acteur (nom exact)	Rôle / missions	Intérêt pour mon projet (données, partenaire, financeur, relais)	Contact (fonction, mail professionnel)
National				
Régional (ARS, DRAAF, Promotion Santé, ORS)				
Départemental (PMI, action sociale)				
Commune / intercommunalité (CCAS, CLS, PAT, politique de la ville)				
Éducation (écoles, collèges, santé scolaire)				
Santé de proximité (MSP, CPTS, médecins)				
Social (centres sociaux, CAF)				
Associations (aide alimentaire, sport, culture, patients)				
Économiques (commerces, marché, producteurs, entreprises)				
Habitants / usagers (groupes, conseils citoyens)				

O1.4 – Inscrire mon projet dans les politiques en vigueur

> **Consigne**
>
> Vérifiez la **version en vigueur** de chaque texte le jour de la rédaction (fiche O1.7). Citez l'axe, l'action ou l'objectif précis, avec la date.

Texte / dispositif	Axe, action ou objectif auquel mon projet répond	Référence (date, lien)
Stratégie nationale de santé		
SNANC 2025-2030		
PNNS 5 (2026-2030)		

Texte / dispositif	Axe, action ou objectif auquel mon projet répond	Référence (date, lien)
PNA 4 (2026-2030)		
Lois (EGalim, Climat et résilience…)		
PRS de ma région (SRS, PRAPS)		
Contrat local de santé		
Projet alimentaire territorial		
Contrat de ville / QPV		
Projet de la structure d'accueil		

Rédaction du paragraphe « contexte » (5 à 8 lignes)

O1.5 – Analyser un projet avec la Charte d'Ottawa

1. Élaborer une politique publique saine

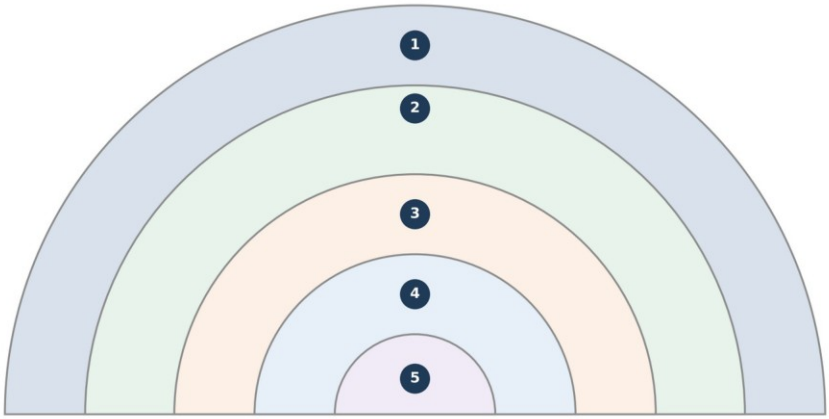
2. Créer des milieux favorables

3. Renforcer l'action communautaire

4. Acquérir des aptitudes individuelles

5. Réorienter les services de santé

O1.6 – Les déterminants de l'alimentation de mon public



Modèle de Dahlgren et Whitehead (1991) – à légender

Couche du modèle	Déterminants observés chez mon public	Levier d'action possible
1. Âge, sexe, hérédité		
2. Style de vie personnel		
3. Réseaux sociaux et communautaires		
4. Conditions de vie et de travail		

Couche du modèle	Déterminants observés chez mon public	Levier d'action possible
5. Conditions socio-économiques, culturelles, environnementales		

O1.7 – Tableau de veille des politiques nutritionnelles

Texte	Version vérifiée	Date de vérification	Statut (en vigueur, en révision, abrogé)	Source (lien) et changement repéré
SNANC	2025-2030 (11/02/2026)	05/10/2026	En vigueur	ecologie.gouv.fr
PNNS	PNNS 5 2026-2030 (08/04/2026)	05/10/2026	En vigueur	sante.gouv.fr ; mangerbouger.fr
PNA	PNA 4 2026-2030	05/10/2026	En vigueur	agriculture.gouv.fr
Repères alimentaires adultes	Santé publique France, 2019	05/10/2026	En vigueur, révision annoncée	mangerbouger.fr
Nutri-Score	Arrêté du 14/03/2025	05/10/2026	En vigueur (transition 2 ans)	sante.fr
EGalim, bilan « ma cantine »				
PRS de ma région				

O1.8 – Check-list éthique et non-stigmatisation d'un message ou d'un support

Critère	Oui / Non	Correction à apporter
Le message est positif et valorise ce que les personnes peuvent faire		
Il évite les mots culpabilisants (« mauvais aliments », « il faut », « interdit »)		
Il n'associe pas poids et valeur de la personne ; pas d'images dégradantes		
Il tient compte des contraintes (budget, temps, équipement)		
Il respecte les cultures et les pratiques religieuses		
Il est lisible (littératie : phrases courtes, pictogrammes, police ≥ 12 pt)		
Il est traduit ou accompagné oralement si nécessaire		
Les informations sont validées, datées et sourcées (repères officiels)		
Aucune marque n'est promue ; pas de conflit d'intérêts		
Les images de personnes ont une autorisation écrite (droit à l'image)		
Aucune donnée personnelle ou de santé n'apparaît		
Le support a été testé auprès de quelques personnes du public		

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES

CHAPITRE

01

La santé publique et la promotion de la santé en nutrition

Santé publique | Promotion de la santé | Politiques nutritionnelles

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 1 114
Mode d'emploi du cahier 114
Partie 1 – Les concepts de santé 115
Exercice 1.1 – Légender l'évolution des concepts de santé (10 points) 116
Exercice 1.2 – Reconnaître un modèle de santé dans un discours (10 points) 117
Exercice 1.3 – Discuter la définition de l'OMS (10 points) 118
Exercice 1.4 – Interpréter un indicateur de santé perçue (12 points) 119
Exercice 1.5 – « Une seule santé » appliquée à la restauration scolaire (12 points) 120
Exercice 1.6 – Rédiger l'introduction d'un dossier E5 (16 points) 122
Corrigés de la partie 1 124
Partie 2 – La santé publique : définitions, missions et approche populationnelle 126
Exercice 2.1 – Légender les missions de la santé publique (9 points) 127
Exercice 2.2 – Approche clinique ou approche de santé publique ? (10 points) 129
Exercice 2.3 – Calculer le paradoxe de la prévention (14 points) 130
Exercice 2.4 – Distinguer incidence et prévalence (10 points) 132
Exercice 2.5 – Les missions de la santé publique face à une toxi-infection alimentaire collective (12 points) 133
Exercice 2.6 – Convaincre des élus d'une action populationnelle (16 points) 134
Corrigés de la partie 2 136
Partie 3 – Problème de santé, danger, risque, facteurs de risque et de protection 138
Exercice 3.1 – Légender la chaîne du risque (12 points) 139
Exercice 3.2 – Classer les notions (10 points) 140
Exercice 3.3 – Calculer et interpréter un risque (12 points) 141
Exercice 3.4 – La listériose chez la femme enceinte (12 points) 142
Exercice 3.5 – Facteurs de risque et facteurs de protection dans un quartier (12 points) 143
Exercice 3.6 – Hiérarchiser des problèmes de santé (16 points) 144
Corrigés de la partie 3 146
Partie 4 – Les modes d'intervention en santé publique 148
Exercice 4.1 – Légender les niveaux de prévention (12 points) 149
Exercice 4.2 – Les 5 domaines et les 3 stratégies de la Charte d'Ottawa (14 points) 151
Exercice 4.3 – Qualifier une action (12 points) 153
Exercice 4.4 – Appliquer l'universalisme proportionné à la cantine (14 points) 154
Exercice 4.5 – Choisir une approche éducative (12 points) 155
Exercice 4.6 – Construire une réponse combinant les quatre modes (16 points) 156
Corrigés de la partie 4 157
Partie 5 – Les acteurs et les organismes de la santé publique en nutrition 159
Exercice 5.1 – Légender la carte des acteurs (10 points) 160
Exercice 5.2 – Qui fait quoi ? (10 points) 162
Exercice 5.3 – Trouver la bonne source de données (12 points) 163
Exercice 5.4 – Construire un plan de financement (12 points) 164
Exercice 5.5 – Repérer un conflit d'intérêts (12 points) 165
Exercice 5.6 – Construire la carte des partenaires d'un projet (16 points) 166
Corrigés de la partie 5 168
Partie 6 – Les politiques publiques de santé et leur déclinaison territoriale 170
Exercice 6.1 – Légender l'architecture de la politique régionale de santé (10 points) 171
Exercice 6.2 – Reconnaître les outils d'une politique publique (10 points) 173
Exercice 6.3 – Les étapes d'une politique publique : l'exemple du PNNS 5 (12 points) 174
Exercice 6.4 – Analyser une fiche-action de contrat local de santé (12 points) 175
Exercice 6.5 – Relier une action locale aux politiques (12 points) 176

Exercice 6.6 – Répondre à un appel à projets de l'ARS (16 points) 177
Corrigés de la partie 6 179
Partie 7 – Les politiques nutritionnelles de santé publique 181
Exercice 7.1 – Légender la frise des politiques nutritionnelles (8 points) 182
Exercice 7.2 – Présenter le PNNS 5 et la SNANC (12 points) 183
Exercice 7.3 – Calculer les taux EGalim d'une cantine (12 points) 184
Exercice 7.4 – Utiliser les repères alimentaires (12 points) 185
Exercice 7.5 – Le Nutri-Score (12 points) 186
Exercice 7.6 – Argumenter une diversification des protéines (16 points) 187
Corrigés de la partie 7 189
Partie 8 – Le diététicien-nutritionniste en santé publique et la démarche de projet 191
Exercice 8.1 – Légender la démarche de projet (10 points) 192
Exercice 8.2 – Le cadre réglementaire de la profession (10 points) 194
Exercice 8.3 – Posture et déontologie en situation (12 points) 195
Exercice 8.4 – Rédiger des objectifs mesurables (12 points) 196
Exercice 8.5 – Classer les besoins selon Bradshaw (10 points) 197
Exercice 8.6 – Cas de synthèse : la santé alimentaire des étudiants d'un campus (30 points) 198
Corrigés de la partie 8 200
Bilan : grille d'auto-évaluation 203

Cahier d'exercices – Chapitre 1

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 1 : concepts de santé, santé publique, danger et risque, modes d'intervention, acteurs, politiques de santé et politiques nutritionnelles, place du diététicien (référentiel du 27 novembre 2024, savoirs associés « Enjeux de santé publique » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas (concepts de santé, « Une seule santé », missions, niveaux de prévention, Charte d'Ottawa, acteurs, projet régional de santé, frise des politiques nutritionnelles, démarche de projet).
- Calculer et interpréter des indicateurs simples (pourcentages, écarts, rapports, nombres de cas évités) et les relier à une décision d'action.
- Qualifier une action de santé publique et l'inscrire dans les politiques en vigueur en octobre 2026.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits de textes), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes et chiffres locaux des mises en situation sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les données nationales, les textes et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026.

Partie 1 – Les concepts de santé

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir la santé selon l'OMS (1946), en citer les apports et les limites.
- Distinguer modèle biomédical, modèle biopsychosocial, santé comme ressource (Charte d'Ottawa) et approche « Une seule santé ».
- Distinguer santé objective, santé perçue et santé positive ; interpréter un indicateur de santé perçue.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- OMS : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » Constitution signée le 22 juillet 1946, en vigueur le 7 avril 1948.
- Modèle biopsychosocial : George Engel, 1977. Charte d'Ottawa (1986) : la santé est « une ressource de la vie quotidienne, et non le but de la vie ».
- Santé comme capacité d'adaptation : Machteld Huber et coll., BMJ, 2011.
- « Une seule santé » (One Health) : principes de Manhattan (2004) ; définition du panel OHHLEP (2021) adoptée par la Quadripartite (OMS, FAO, OMSA, PNUE) ; plan d'action conjoint 2022-2026.
- Santé perçue : déclarée par la personne ; elle prédit la mortalité indépendamment des indicateurs médicaux.

Exercice 1.1 – Légender l'évolution des concepts de santé (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez l'introduction de votre dossier E5 et vous voulez montrer au jury que votre projet s'appuie sur une conception actuelle de la santé.

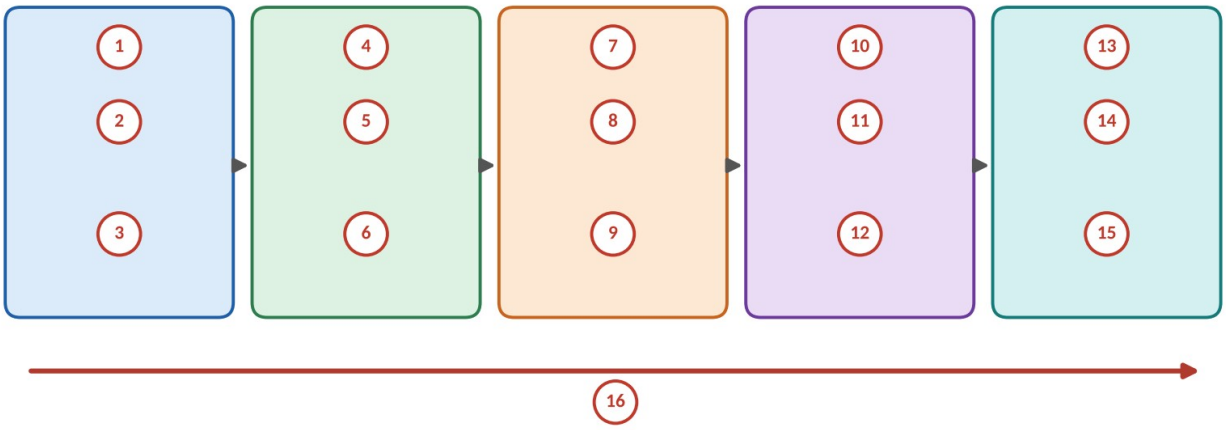


Figure 1.1 – Document 1 – L'évolution des concepts de santé (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 16 du document 1 (nom du modèle, date ou auteur, idée principale). (6 pts)
2. Expliquez le sens de la flèche rouge placée sous le schéma. (2 pts)
3. Indiquez quel modèle justifie qu'un diététicien agisse sur les menus d'une cantine plutôt que seulement en consultation. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 1.2 – Reconnaître un modèle de santé dans un discours (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une réunion de préparation d'un forum santé dans une commune, vous notez les phrases prononcées par les participants.

Document 1 – Phrases entendues pendant la réunion

a) Le médecin : « Les habitants dont la glycémie est normale sont en bonne santé, on n'a pas besoin de s'occuper d'eux. »

b) L'adjointe aux affaires sociales : « Sans logement correct et sans revenu, on ne peut pas parler de santé. »

c) Une habitante qui a un diabète de type 1 depuis 20 ans : « Je cours des semi-marathons, je travaille, je me sens bien : je suis en bonne santé. »

d) Le responsable de la restauration scolaire : « En servant moins de viande et plus de légumineuses, on agit pour les enfants, pour les élevages et pour le climat. »

e) La psychologue du centre médico-psychologique : « Le stress au travail et l'isolement expliquent une partie des grignotages que nous voyons. »

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque phrase à un modèle ou à un concept de santé ; justifiez en une phrase. (5 × 1,5 pt)

2. Montrez, à partir de la phrase c, une limite de la définition de l'OMS. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 1.3 – Discuter la définition de l'OMS (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Madame L., 34 ans, a une maladie cœliaque diagnostiquée il y a 8 ans. Elle suit un régime strict sans gluten, ses anticorps sont négatifs, elle travaille à temps plein et anime une association de patients. Elle vous dit : « Selon la définition officielle, je ne serai jamais en bonne santé, puisque je suis malade à vie. »

Document 1 – Deux définitions

Définition de l'OMS (1946) : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. »

Proposition de M. Huber et coll. (BMJ, 2011) : la santé comme « capacité à s'adapter et à se prendre en charge face aux défis sociaux, physiques et émotionnels ».

À vous de jouer – Questions

1. Citez les trois apports de la définition de l'OMS qui l'ont rendue novatrice en 1946. (3 pts)
2. Présentez trois critiques de cette définition. (3 pts)
3. Montrez que la proposition de Huber permet de considérer que Madame L. est en bonne santé. (2 pts)
4. Indiquez ce que cette réflexion change dans la façon d'animer un atelier pour des personnes atteintes d'une maladie chronique. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 1.4 – Interpréter un indicateur de santé perçue (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'observatoire de la santé d'une agglomération (données fictives) a interrogé 2 800 adultes, répartis en quatre groupes égaux de revenus (quartiles). Vous devez présenter ces résultats au comité de pilotage d'un projet « Alimentation et santé » de l'agglomération.

Document 1 – Adultes se déclarant en bonne ou très bonne santé, selon le revenu (enquête fictive, 2025)

Quartile de revenu	Effectif interrogé	Adultes se déclarant en bonne ou très bonne santé
Quartile 1 (25 % les plus modestes)	700	412
Quartile 2	700	498
Quartile 3	700	553
Quartile 4 (25 % les plus aisés)	700	602

À vous de jouer – Questions

1. Définissez la santé perçue et indiquez pourquoi c'est un indicateur utile en santé publique. (2 pts)
2. Calculez, pour chaque quartile, la part des adultes en bonne ou très bonne santé. (4 pts)
3. Calculez l'écart absolu (en points) et le rapport entre le quartile 4 et le quartile 1 ; interprétez. (3 pts)
4. Nommez le phénomène mis en évidence et indiquez une conséquence pour la conception du projet. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 1.5 – « Une seule santé » appliquée à la restauration scolaire (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage auprès du service de restauration d'une commune de 18 000 habitants (structure fictive). Les élus veulent présenter au conseil municipal le passage à deux repas végétariens par semaine dans les écoles et l'achat de volailles élevées sans antibiotiques. Ils vous demandent un schéma et un argumentaire « Une seule santé ».

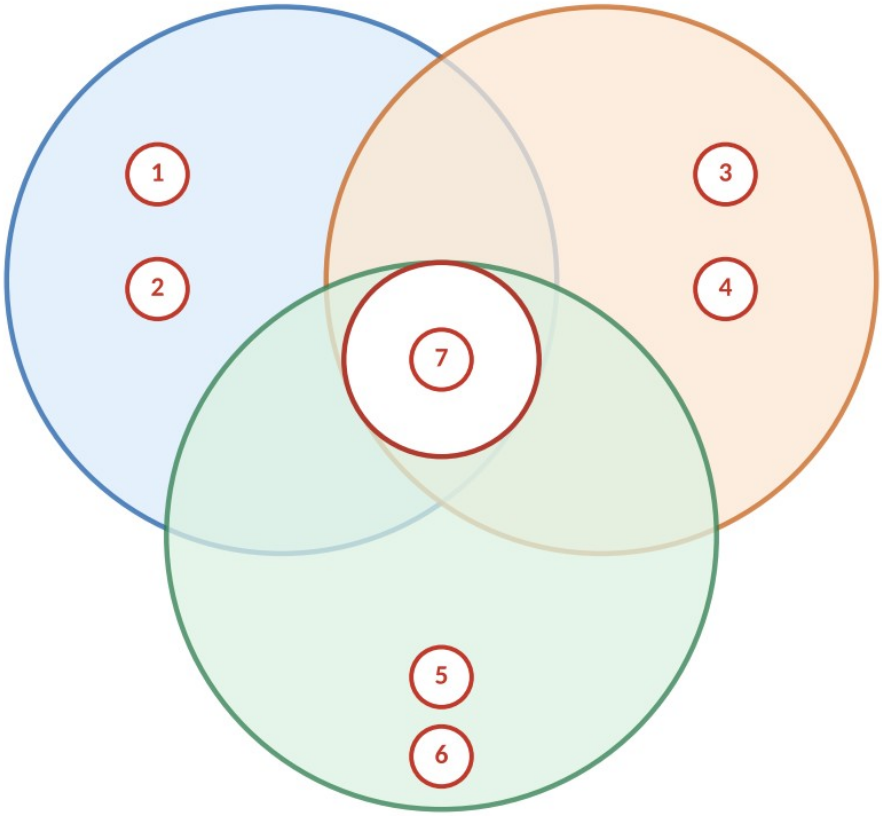


Figure 1.2 – Document 1 – « Une seule santé » (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés du document 1. (3,5 pts)
2. Donnez la définition de l'approche « Une seule santé » et citez les quatre organisations de la Quadripartite. (2,5 pts)
3. Montrez, pour chacune des deux mesures, ses effets attendus sur les trois santés. (4 pts)
4. Indiquez deux points de vigilance nutritionnelle qui relèvent du diététicien pour les repas végétariens des enfants. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 1.6 – Rédiger l'introduction d'un dossier E5 (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage dans un centre social qui accueille des familles d'un quartier prioritaire de la politique de la ville (structure fictive). Votre projet porte sur un « café des parents » consacré à l'alimentation des enfants de 3 à 6 ans. Votre tutrice vous demande de rédiger l'introduction du dossier, d'une demi-page, en montrant au lecteur que l'action ne se limite pas à « donner des conseils ».

Document 1 – Notes prises pendant l'observation

- 28 familles inscrites au centre social ont un enfant de 3 à 6 ans ; 11 familles vivent dans un logement sans four.
- Les parents disent manquer de temps et d'argent ; certains se sentent jugés par l'école sur le contenu du goûter.
- Le marché du quartier a lieu le samedi ; la supérette la plus proche vend peu de fruits et légumes frais.
- Les parents demandent des idées de goûters « que les enfants aiment et qui ne coûtent pas cher ».

À vous de jouer – Questions

1. Identifiez, dans le document 1, les éléments qui relèvent de chacune des trois dimensions du modèle biopsychosocial. (4,5 pts)
2. Montrez que la situation illustre la santé comme « ressource de la vie quotidienne » au sens de la Charte d'Ottawa. (3 pts)
3. Rédigez l'introduction du dossier (une demi-page) : définition de la santé retenue, justification de l'approche, annonce du projet. (6 pts)
4. Relevez une phrase du document 1 qui doit vous alerter sur le risque de stigmatisation et indiquez comment vous en tenez compte. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 1.1

1. Légendes : 1 Modèle biomédical ; 2 XIXe siècle – milieu du XXe ; 3 Santé = absence de maladie, action curative et individuelle ; 4 Définition de l'OMS ; 5 1946 (en vigueur en 1948) ; 6 Bien-être physique, mental et social, droit fondamental ; 7 Modèle biopsychosocial ; 8 Engel, 1977 ; 9 Interaction de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux ; 10 Charte d'Ottawa ; 11 1986 ; 12 Santé = ressource de la vie quotidienne, promotion de la santé ; 13 Une seule santé ; 14 Principes de Manhattan, 2004 ; 15 Santé humaine, animale et des écosystèmes liées ; 16 De l'individu malade à la population, puis à la planète.
2. La flèche montre l'élargissement du regard : on passe d'une santé définie chez l'individu malade (soigner) à une santé de la population, dépendant de ses conditions de vie (prévenir, promouvoir), puis à une santé liée à celle des animaux et des écosystèmes (alimentation durable).
3. Le modèle biopsychosocial et la Charte d'Ottawa : la santé dépend des conditions de vie et des milieux (ici le milieu scolaire). Agir sur les menus, c'est « créer des milieux favorables », un des cinq domaines d'action de la Charte.

Corrigé – Exercice 1.2

1. a) Modèle biomédical : la santé est réduite à un résultat biologique normal ; on ignore le vécu et les déterminants. b) Charte d'Ottawa : le logement et le revenu font partie des conditions préalables à la santé (paix, abri, éducation, nourriture, revenu, écosystème stable, ressources durables, justice sociale et équité). c) Santé comme capacité d'adaptation (Huber, 2011) et santé perçue : malgré une maladie chronique, la personne fonctionne et se sent bien. d) « Une seule santé » : la mesure agit sur la santé humaine, la santé animale et l'environnement. e) Modèle biopsychosocial : des facteurs psychologiques (stress) et sociaux (isolement) expliquent un comportement alimentaire.
2. Selon l'OMS, la santé est un état de « complet » bien-être : une personne qui a une maladie chronique ne pourrait jamais être en bonne santé. Or l'habitante de la phrase c mène une vie pleinement satisfaisante. La définition décrit un idéal figé et ne tient pas compte de la capacité d'adaptation.

Corrigé – Exercice 1.3

1. Apports : définition positive (le bien-être et pas seulement l'absence de maladie) ; multidimensionnelle (physique, mentale, sociale) ; la santé est un droit fondamental de tout être humain.
2. Critiques : le « complet » bien-être est un idéal presque inatteignable ; c'est un état figé alors que la santé est un équilibre dynamique ; la définition ne dit rien de la capacité d'adaptation et exclut les personnes qui vivent bien avec une maladie chronique ; elle est difficile à mesurer.
3. Madame L. s'adapte à sa maladie : elle suit son régime, ses anticorps sont négatifs, elle travaille et s'engage dans une association. Selon Huber, elle a la capacité de faire face aux défis physiques, sociaux et émotionnels : elle est en bonne santé, même si elle a une maladie chronique.
4. L'atelier part des ressources et des compétences des participants, et pas seulement de leurs « problèmes » ; il valorise ce qu'ils savent déjà faire, cherche à renforcer leur autonomie (pouvoir d'agir) et évite un discours centré sur la maladie et les interdits.

Corrigé – Exercice 1.4

1. La santé perçue est l'état de santé déclaré par la personne elle-même (« Comment jugez-vous votre état de santé ? »). Elle est simple à recueillir, comparable entre groupes et dans le temps, et elle prédit la mortalité indépendamment des indicateurs médicaux. Elle est utilisée dans le Baromètre de Santé publique France et l'enquête européenne EHIS.
2. Calculs (nombre de réponses / 700 × 100) : quartile 1 : 412 / 700 × 100 = 58,9 % ; quartile 2 : 498 / 700 × 100 = 71,1 % ; quartile 3 : 553 / 700 × 100 = 79,0 % ; quartile 4 : 602 / 700 × 100 = 86,0 %.

3. Écart absolu = 86,0 − 58,9 = 27,1 points. Rapport = 86,0 / 58,9 = 1,46. Les adultes les plus aisés sont 1,46 fois plus nombreux, en proportion, à se déclarer en bonne santé que les plus modestes.

4. La part des adultes en bonne santé augmente à chaque quartile de revenu : c'est un gradient social de santé, expression des inégalités sociales de santé. Conséquence : le projet doit être ouvert à tous mais renforcé pour les plus modestes (universalisme proportionné), en agissant aussi sur l'accès (prix, proximité) et pas seulement sur l'information.

Corrigé – Exercice 1.5

1. Légendes : 1 Santé humaine ; 2 maladies chroniques, carences, antibiorésistance ; 3 Santé animale ; 4 élevage, bien-être animal, zoonoses ; 5 Santé des écosystèmes ; 6 climat, sols, eau, biodiversité ; 7 Alimentation durable.

2. Définition (OHHLEP, 2021) : « une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes ». Quadripartite : OMS, FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture), OMSA (Organisation mondiale de la santé animale), PNUE (Programme des Nations unies pour l'environnement).

3. Repas végétariens : santé humaine (plus de fibres, moins d'acides gras saturés si le menu est équilibré) ; écosystèmes (moins d'émissions de gaz à effet de serre, les légumineuses fixent l'azote de l'air) ; santé animale (moindre pression sur l'élevage intensif). Volailles sans antibiotiques : santé animale (élevage qui doit prévenir les maladies autrement) ; santé humaine (limitation de la sélection de bactéries résistantes) ; écosystèmes (moins de résidus et de bactéries résistantes dans les sols et l'eau).

4. Vigilance : apport en protéines (associer légumineuses et céréales, prévoir œufs ou produits laitiers) et en fer (légumineuses avec une source de vitamine C) ; acceptabilité par les enfants (recettes, goût, textures) pour éviter le gaspillage ; grammages adaptés à l'âge.

Corrigé – Exercice 1.6

1. Dimension biologique : enfants de 3 à 6 ans (besoins de croissance, goût en construction). Dimension psychologique : parents qui se sentent jugés ; envie de faire plaisir à l'enfant. Dimension sociale : manque d'argent et de temps, logement sans four (11 familles sur 28, soit 39,3 %), offre alimentaire du quartier pauvre en produits frais.

2. La santé des enfants dépend de ressources de la vie quotidienne : revenu, logement équipé, commerces accessibles, temps disponible, confiance des parents. L'action doit renforcer ces ressources (compétences, accès, soutien entre parents) et pas seulement transmettre des informations.

3. Exemple d'introduction : « Depuis la Charte d'Ottawa (1986), la santé n'est plus seulement l'absence de maladie : c'est une ressource de la vie quotidienne, qui dépend des conditions de vie autant que des comportements. Au centre social, les familles disent manquer de temps et d'argent ; 11 des 28 familles ayant un enfant de 3 à 6 ans n'ont pas de four, et l'offre de fruits et légumes frais du quartier est limitée. Dans ce contexte, des conseils seuls ne suffiraient pas. Le projet « café des parents » propose donc un espace d'échange et de pratique, construit avec les familles, pour partager des idées de goûters simples, appréciés des enfants et peu coûteux, et pour faciliter l'accès aux produits frais du marché. »

4. Phrase : « certains se sentent jugés par l'école sur le contenu du goûter ». On évite tout message culpabilisant (« bons » et « mauvais » goûters), on part de ce que font déjà les parents, on valorise les réussites, on relit les supports avec la check-list éthique et non-stigmatisation.

Partie 2 – La santé publique : définitions, missions et approche populationnelle

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir la santé publique (Winslow, 1920) et la politique de santé (article L. 1411-1 du code de la santé publique).
- Distinguer l'approche clinique et l'approche de santé publique.
- Citer les missions de la santé publique et les relier à des actions concrètes en nutrition.
- Expliquer et calculer le paradoxe de la prévention (Rose, 1985) ; distinguer incidence et prévalence.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Santé publique : ensemble des savoirs, des savoir-faire et des actions organisées qui visent à maintenir et améliorer la santé de la population, en agissant collectivement sur ses déterminants (Winslow, 1920 : « la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et de promouvoir la santé… »).
- Neuf missions : observer et surveiller ; veiller et alerter ; protéger ; promouvoir ; prévenir ; éduquer et informer ; organiser ; former, chercher, évaluer ; gouverner.
- Paradoxe de la prévention (Geoffrey Rose, 1985) : un grand nombre de personnes exposées à un petit risque peut produire plus de cas qu'un petit nombre de personnes à haut risque.
- Prévalence = cas existants / population à un moment donné. Incidence = nouveaux cas pendant une période / population à risque au début de la période.

Exercice 2.1 – Légender les missions de la santé publique (9 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une affiche pour présenter la santé publique aux étudiants de première année lors d'une journée portes ouvertes.

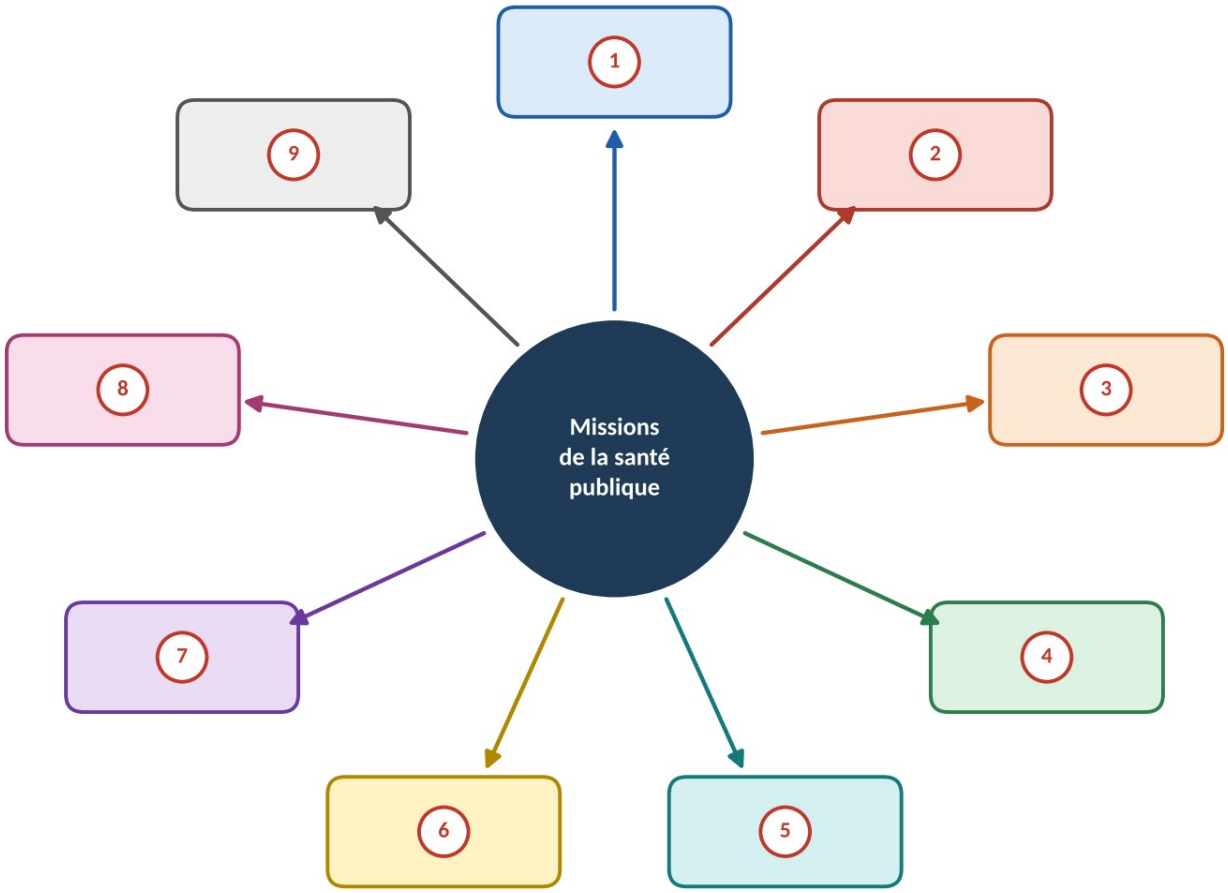


Figure 2.1 – Document 1 – Les missions de la santé publique (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les cases 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)

2. Pour les missions 1, 2, 4, 5 et 6, donnez un exemple d'action en nutrition. (4,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.2 – Approche clinique ou approche de santé publique ? (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pendant votre stage dans une maison de santé pluriprofessionnelle (structure fictive), vous relevez les activités de la diététicienne pendant une semaine.

Document 1 – Activités de la semaine

a) Consultation d'un patient diabétique adressé par son médecin.

b) Analyse des données de corpulence des enfants des 4 écoles de la commune, transmises par la santé scolaire.

c) Animation d'un atelier « petits-déjeuners » pour toutes les classes de CE2 de la commune.

d) Bilan nutritionnel d'une patiente dénutrie à domicile.

e) Réunion avec la mairie pour installer des fontaines à eau dans les écoles.

f) Rédaction d'un plan de soins diététiques pour un patient insuffisant rénal.

g) Participation au comité de pilotage du contrat local de santé.

h) Conception d'un questionnaire sur l'alimentation des seniors de la commune.

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque activité dans l'approche clinique ou dans l'approche de santé publique. (4 pts)
2. Comparez les deux approches selon 6 critères : cible, point de départ, objectif, leviers, acteurs, évaluation. (6 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.3 – Calculer le paradoxe de la prévention (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une agglomération de 60 000 adultes (données fictives) veut réduire le nombre d'accidents vasculaires cérébraux (AVC). Deux stratégies sont proposées au conseil communautaire : un programme intensif pour les personnes hypertendues, ou une action sur toute la population pour réduire la consommation de sel (pain, restauration collective, ateliers).

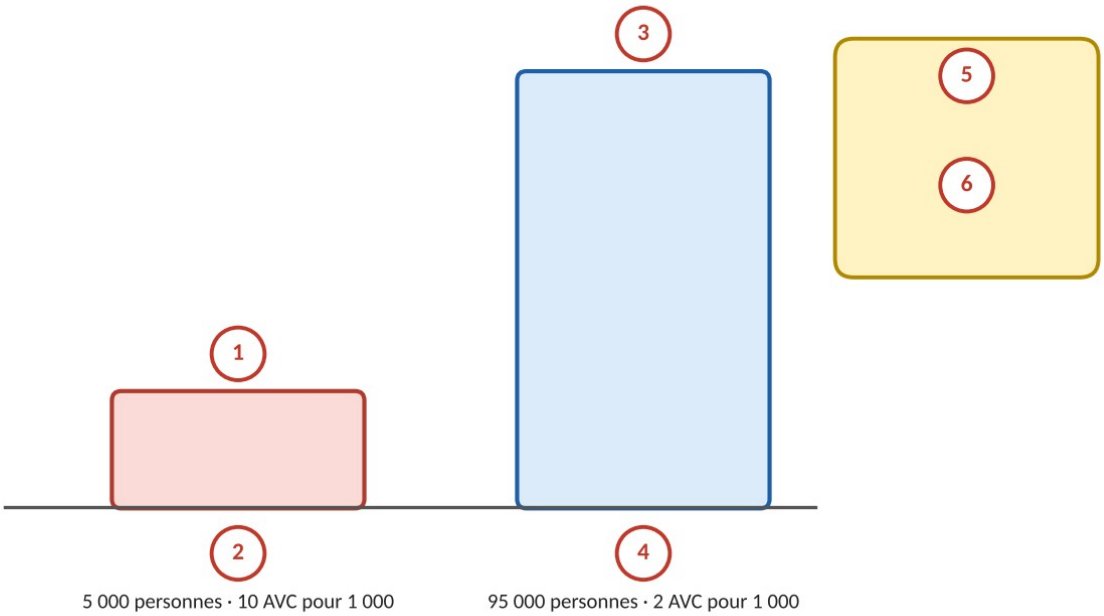


Figure 2.2 – Document 1 – Le paradoxe de la prévention, exemple du cours (schéma à légender)

Document 2 – Données de l'agglomération (fictives, risque sur 10 ans)

Groupe	Effectif	AVC attendus sur 10 ans pour 1 000 personnes
Hypertension sévère (haut risque)	6 000	12
Pression artérielle normale ou modérément élevée (faible risque)	54 000	3

Stratégie A (haut risque) : le programme intensif réduit de 30 % le risque des seules personnes à haut risque.

Stratégie B (population) : l'action sur le sel réduit de 10 % le risque de toute la population.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez le document 1. (3 pts)
2. Calculez le nombre d'AVC attendus sur 10 ans dans chaque groupe, puis au total. (3 pts)
3. Calculez la part des AVC qui surviennent dans le groupe à faible risque ; concluez. (2 pts)
4. Calculez le nombre d'AVC évités par la stratégie A et par la stratégie B. (3 pts)
5. Argumentez le choix d'une stratégie en citant le paradoxe de Rose et une limite de chaque stratégie. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.4 – Distinguer incidence et prévalence (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de santé scolaire d'une circonscription (données fictives) suit 2 400 enfants de CM1. En septembre, 312 enfants sont en surpoids (obésité comprise). En juin, 48 nouveaux enfants sont en surpoids parmi ceux qui ne l'étaient pas en septembre.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez la prévalence et l'incidence. (2 pts)
2. Calculez la prévalence du surpoids en septembre. (2 pts)
3. Calculez l'incidence cumulée du surpoids entre septembre et juin, en précisant la population à risque. (3 pts)
4. Indiquez quel indicateur une action de prévention primaire cherche à faire baisser, et quel indicateur baisse avec une prévention secondaire ; justifiez. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.5 – Les missions de la santé publique face à une toxi-infection alimentaire collective (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un jeudi, 23 élèves et 2 agents d'une école primaire (structure fictive) présentent des vomissements et des diarrhées 4 à 6 heures après le déjeuner servi par la cuisine centrale. La directrice appelle le médecin scolaire.

Document 1 – Ce qui se passe dans les jours suivants

a) Le médecin déclare la toxi-infection alimentaire collective (TIAC) à l'agence régionale de santé.

b) Les plats témoins conservés par la cuisine centrale sont analysés.

c) La direction départementale chargée de la protection des populations inspecte la cuisine centrale.

d) Santé publique France intègre l'épisode dans la surveillance nationale des TIAC.

e) Le maire suspend la préparation des plats concernés jusqu'au rapport d'inspection.

f) La diététicienne de la cuisine centrale anime une formation sur le maintien en température pour les agents.

g) Une lettre d'information est envoyée aux familles.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez la TIAC (au moins 2 cas groupés d'une symptomatologie similaire, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire) et rappelez qu'elle est une maladie à déclaration obligatoire. (2 pts)
2. Associez chaque action du document 1 à une mission de la santé publique. (7 pts)
3. Indiquez le rôle du diététicien dans la prévention des TIAC en restauration collective. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.6 – Convaincre des élus d'une action populationnelle (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

En stage au service santé d'une ville de 35 000 habitants (structure fictive), vous devez préparer une note d'une page pour les élus. Le projet propose de travailler avec les boulangers volontaires de la ville pour réduire progressivement le sel du pain, et de réduire le sel des plats servis dans les cantines et au portage de repas des seniors. Un élu objecte : « Seuls les hypertendus sont concernés ; il suffit que leurs médecins s'en occupent. »

Document 1 – Extraits de textes

- Article L. 1411-1 du code de la santé publique : la politique de santé « tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l'amélioration de l'état de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales [...] ».
- OMS : recommandation de moins de 5 g de sel par jour pour un adulte.
- Le pain fait partie des principaux contributeurs de l'apport en sel en France (études de consommation de l'ANSES).

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez à l'élu, avec le paradoxe de Rose, pourquoi une action sur toute la population est pertinente. (4 pts)
2. Montrez que le projet répond à la définition de la politique de santé du document 1. (3 pts)
3. Identifiez les missions de la santé publique mobilisées par le projet. (3 pts)
4. Rédigez la note d'une page aux élus : contexte, objectif, actions, partenaires, évaluation. (6 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 2.1

1. Légendes : 1 Observer et surveiller ; 2 Veiller et alerter ; 3 Protéger ; 4 Promouvoir la santé ; 5 Prévenir ; 6 Éduquer et informer ; 7 Organiser le système de santé ; 8 Former, chercher, évaluer ; 9 Gouverner.
2. Exemples : observer et surveiller : étude ESTEBAN ou INCA, enquêtes de santé scolaire ; veiller et alerter : déclaration d'une TIAC, nutrivigilance des compléments alimentaires ; promouvoir : installation de fontaines à eau, charte « Ville active du PNNS » ; prévenir : dépistage de la dénutrition à l'entrée en EHPAD ; éduquer et informer : atelier de lecture d'étiquettes, campagne « Manger Bouger ».

Corrigé – Exercice 2.2

1. Approche clinique : a, d, f. Approche de santé publique : b, c, e, g, h.
2. Comparaison :

Critère	Approche clinique	Approche de santé publique
Cible	Un individu, le patient	Une population ou un groupe
Point de départ	Une demande de soin, une prescription	Un diagnostic de situation (données, besoins)
Objectif	Guérir, soulager, accompagner	Maintenir et améliorer la santé du groupe, réduire les inégalités
Leviers	Bilan, diagnostic diététique, plan de soins, ETP	Environnements, politiques, communication, éducation, partenariats
Acteurs	Équipe soignante	Équipe pluridisciplinaire et intersectorielle
Évaluation	Évolution clinique du patient	Indicateurs de processus et de résultats sur le groupe

Corrigé – Exercice 2.3

1. Légendes du document 1 : 1 50 AVC ; 2 Groupe à haut risque ; 3 190 AVC ; 4 Groupe à faible risque ; 5 Paradoxe de la prévention ; 6 La majorité des cas vient du grand nombre de personnes à faible risque.
2. AVC attendus = effectif × risque / 1 000. Haut risque : 6 000 × 12 / 1 000 = 72 AVC. Faible risque : 54 000 × 3 / 1 000 = 162 AVC. Total : 72 + 162 = 234 AVC.
3. Part dans le groupe à faible risque = 162 / 234 × 100 = 69,2 %. Plus des deux tiers des AVC surviennent chez des personnes à faible risque, simplement parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses.
4. Stratégie A : 72 × 0,30 = 21,6, soit environ 22 AVC évités. Stratégie B : 234 × 0,10 = 23,4, soit environ 23 AVC évités.
5. La stratégie B évite autant ou un peu plus d'AVC alors que la réduction du risque individuel est faible (10 %) : c'est le paradoxe de Rose, une mesure qui apporte peu à chaque personne apporte beaucoup à la population. Limites : la stratégie A ne touche que 10 % de la population et ignore la majorité des cas ; la stratégie B apporte un bénéfice individuel faible, donc peu motivant, et doit être maintenue longtemps. Le mieux est de combiner les deux.

Corrigé – Exercice 2.4

1. Prévalence : nombre de cas existants dans une population à un moment donné, rapporté à cette population. Incidence : nombre de nouveaux cas apparus pendant une période, rapporté à la population à risque (non malade) au début de la période.
2. Prévalence en septembre = 312 / 2 400 × 100 = 13,0 %.
3. Population à risque = enfants sans surpoids en septembre = 2 400 − 312 = 2 088. Incidence cumulée = 48 /

2 088 × 100 = 2,3 % sur l'année scolaire.

4. La prévention primaire évite l'apparition de nouveaux cas : elle fait baisser l'incidence. La prévention secondaire repère et prend en charge tôt les cas existants, ce qui raccourcit la durée du problème : elle fait baisser la prévalence.

Corrigé – Exercice 2.5

1. TIAC : apparition d'au moins 2 cas groupés d'une symptomatologie similaire, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire. C'est une maladie à déclaration obligatoire auprès de l'ARS.

2. a) Veiller et alerter ; b) observer (investigation, recherche de l'agent) et protéger ; c) protéger (contrôle de la sécurité sanitaire) ; d) observer et surveiller ; e) protéger (mesure de gestion du risque) ; f) éduquer et former ; g) informer.

3. Le diététicien participe au plan de maîtrise sanitaire (méthode HACCP, bonnes pratiques d'hygiène), forme les agents, vérifie les températures et la traçabilité, conserve les plats témoins, choisit des recettes et des procédés à moindre risque et participe à l'investigation en cas de TIAC.

Corrigé – Exercice 2.6

1. L'hypertension et ses complications ne surviennent pas seulement chez les personnes déjà hypertendues : comme l'a montré Rose, le grand nombre de personnes à risque faible ou modéré produit une grande partie des cas. Réduire un peu le sel consommé par tous (pain, cantines, portage) déplace vers le bas la pression artérielle moyenne de toute la population et évite davantage de cas que l'action sur les seuls hypertendus. Les médecins restent indispensables pour les personnes à haut risque : les deux actions se complètent.

2. Le projet crée des conditions de vie favorables à la santé (pain et repas moins salés, sans effort individuel) ; il vise l'amélioration de l'état de santé de la population ; il réduit les inégalités, car il bénéficie à tous, y compris aux personnes qui ont moins accès à la prévention individuelle (seniors portés à domicile, enfants des cantines).

3. Promouvoir (environnement alimentaire), prévenir (prévention primaire universelle de l'hypertension), protéger, éduquer et informer (ateliers, communication), observer et évaluer (mesure du sel), gouverner (décision des élus, partenariat avec les boulangers).

4. Exemple de note : contexte (l'OMS recommande moins de 5 g de sel par jour ; le pain est un contributeur majeur ; l'hypertension est un facteur de risque majeur d'AVC) ; objectif (réduire progressivement la teneur en sel du pain des boulangeries volontaires et des repas de la restauration municipale en 2 ans) ; actions (charte avec les boulangers, réduction par paliers pour préserver le goût, adaptation des recettes en cuisine centrale, ateliers « goût sans sel » avec les herbes et les épices, information des habitants) ; partenaires (boulangers, chambre de métiers, cuisine centrale, CCAS, ARS au titre du CLS) ; évaluation (teneur en sel mesurée ou déclarée, nombre de boulangeries engagées, ventes, satisfaction des convives, suivi des plaintes sur le goût).

Partie 3 – Problème de santé, danger, risque, facteurs de risque et de protection

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir problème de santé, danger, exposition, risque, facteur de risque, facteur de protection et population à risque.
- Identifier ces notions dans une situation professionnelle et calculer un risque simple.
- Hiérarchiser des problèmes de santé avec des critères explicites.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Danger : propriété intrinsèque d'un agent ou d'une situation capable de provoquer un effet néfaste.
- Exposition : contact entre la population et le danger (dose, durée, fréquence).
- Risque : probabilité qu'un effet néfaste survienne, compte tenu du danger et de l'exposition (risque = danger × exposition).
- Facteur de risque : caractéristique associée à une probabilité accrue de maladie, sans être forcément la cause. Facteur de protection : associé à une probabilité réduite.
- Critères de priorité d'un problème de santé : fréquence, gravité, évolution, coût, existence de moyens d'action efficaces, demande de la population.

Exercice 3.1 – Légender la chaîne du risque (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une séance de formation pour les animateurs d'un centre de loisirs sur la sécurité des goûters et l'alimentation des enfants.

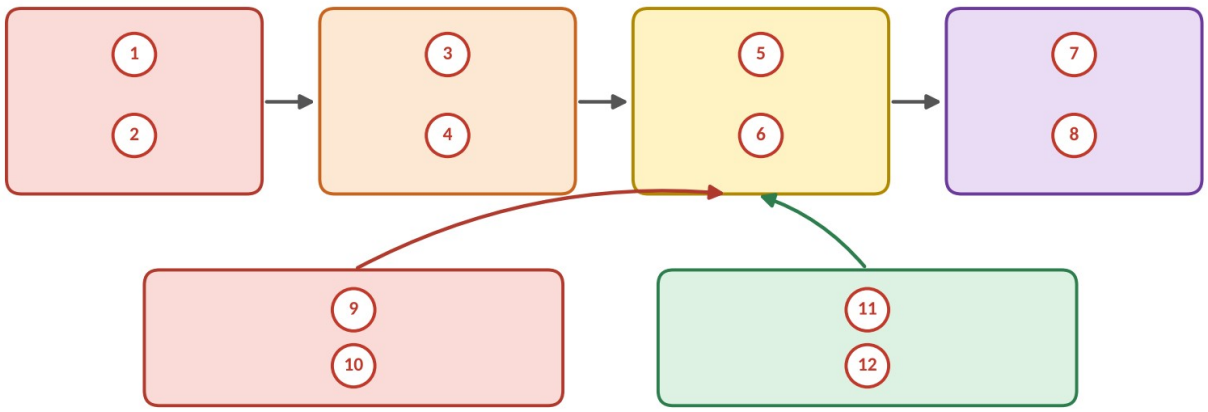


Figure 3.1 – Document 1 – Du danger au problème de santé (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés du document 1. (6 pts)
2. Appliquez la chaîne au cas d'un enfant allergique à l'arachide qui participe à un goûter d'anniversaire : danger, exposition, risque, facteur de risque, facteur de protection. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi, avec le même danger, le risque peut être nul. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.2 – Classer les notions (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Document 1 – Dix éléments relevés dans des situations de stage

a) Listeria monocytogenes. b) Consommation quotidienne de plats préparés riches en sel. c) Probabilité de développer une hypertension dans une population qui mange très salé. d) Allaitement maternel. e) Femmes enceintes face à la listériose. f) Sédentarité. g) Obésité des enfants d'un quartier, mesurée par la santé scolaire. h) Soutien social d'une personne âgée vivant seule. i) Faible revenu. j) Consommation de fruits, de légumes et de fibres.

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque élément : problème de santé, danger, exposition, risque, facteur de risque, facteur de protection ou population à risque. (10 × 1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.3 – Calculer et interpréter un risque (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un observatoire régional (données fictives) a suivi pendant 3 ans 1 200 adolescents de 12 ans sans surpoids au départ. Au début du suivi, 400 adolescents buvaient chaque jour au moins une boisson sucrée ; 800 n'en buvaient pas chaque jour.

Document 1 – Résultats après 3 ans

Groupe	Effectif au départ	Adolescents en surpoids après 3 ans
Boisson sucrée chaque jour	400	64
Pas de boisson sucrée chaque jour	800	72

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le risque de devenir en surpoids en 3 ans dans chaque groupe. (3 pts)
2. Calculez le rapport des deux risques (risque relatif) et interprétez-le. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi la boisson sucrée quotidienne est un facteur de risque, mais pas forcément la cause unique du surpoids ; citez deux autres facteurs qui peuvent intervenir. (3 pts)
4. Proposez une action de promotion de la santé et une action d'éducation pour la santé qui découlent de ce résultat. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.4 – La listériose chez la femme enceinte (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez avec la sage-femme de la PMI une séance collective pour des femmes enceintes. L'une d'elles dit : « Ma mère a mangé du fromage au lait cru pendant toutes ses grossesses et nous allons très bien. »

Document 1 – Informations de référence

La listériose est une infection due à Listeria monocytogenes, une bactérie présente dans l'environnement qui peut se multiplier au réfrigérateur. Elle est rare mais grave : chez la femme enceinte, elle peut provoquer une fausse couche, un accouchement prématuré ou une infection grave du nouveau-né. Les personnes les plus exposées à une forme grave sont les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Les aliments à éviter pendant la grossesse comprennent notamment les fromages au lait cru, les charcuteries à la coupe, les poissons fumés et les graines germées crues.

À vous de jouer – Questions

1. Identifiez le danger, l'exposition, le risque et la population à risque. (4 pts)
2. Expliquez à cette femme pourquoi l'expérience de sa mère ne prouve pas l'absence de risque (rareté de l'événement, probabilité). (3 pts)
3. Proposez quatre conseils pratiques de prévention, formulés de façon positive. (4 pts)
4. Indiquez le niveau de prévention (OMS) et le type (Gordon) de cette séance. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.5 – Facteurs de risque et facteurs de protection dans un quartier (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un quartier prioritaire (données fictives), la santé scolaire observe que 21 % des élèves de CM2 sont en surpoids, contre 15 % dans le reste de la ville. Un élu en conclut : « Le quartier rend les enfants gros. »

Document 1 – Observations du diagnostic de quartier

- Deux supermarchés discount et une supérette ; le marché a lieu une fois par semaine.
- Un city-stade fermé depuis deux ans ; peu d'espaces verts.
- Taux de chômage élevé ; beaucoup de familles monoparentales.
- Une association de parents très active ; un jardin partagé créé en 2024 ; une école qui participe à un programme de fruits à la récréation.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'écart de prévalence entre le quartier et le reste de la ville, en points et en rapport. (2 pts)

2. Expliquez pourquoi la phrase de l'élu est une erreur de raisonnement. (3 pts)

3. Classez les observations du document 1 en facteurs de risque et en facteurs de protection. (4 pts)

4. Proposez deux actions qui renforcent les facteurs de protection existants. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.6 – Hiérarchiser des problèmes de santé (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le comité de pilotage du contrat local de santé d'une communauté de communes (données fictives) dispose d'un budget pour une seule action de nutrition en 2027. Quatre problèmes ont été repérés. Votre tutrice vous demande de construire une grille de priorisation et de présenter un choix argumenté.

Document 1 – Notes attribuées par le groupe de travail (1 = faible, 3 = élevé)

Problème	Fréquence	Gravité	Évolution et coût	Faisabilité (moyens efficaces disponibles)	Demande de la population
Surpoids des enfants	3	2	2	2	2
Dénutrition des seniors à domicile	2	3	2	3	1
Insécurité alimentaire des familles	3	2	2	2	3
Faible consommation de légumineuses	3	1	1	3	1

Pondération retenue : fréquence × 2 ; gravité × 3 ; évolution et coût × 1 ; faisabilité × 2 ; demande × 1.

À vous de jouer – Questions

1. Citez les critères habituels de priorisation d'un problème de santé et justifiez la pondération plus forte de la gravité. (3 pts)
2. Calculez le score pondéré de chaque problème et classez-les. (5 pts)
3. Discutez le résultat : écart entre les scores, subjectivité des notes, problème qui touche peu de personnes mais qui est grave. (4 pts)
4. Rédigez la recommandation au comité de pilotage en 5 lignes. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 3.1

1. Légendes : 1 Danger ; 2 propriété d'un agent capable de nuire ; 3 Exposition ; 4 contact : dose, durée, fréquence ; 5 Risque ; 6 probabilité de survenue de l'effet néfaste ; 7 Problème de santé ; 8 mesuré par des indicateurs ; 9 Facteurs de risque ; 10 augmentent la probabilité (sédentarité, boissons sucrées, faible revenu) ; 11 Facteurs de protection ; 12 diminuent la probabilité (fibres, activité physique, soutien social).
2. Danger : l'arachide (allergène). Exposition : ingestion de gâteaux ou de biscuits contenant de l'arachide ou des traces, au goûter. Risque : probabilité d'une réaction allergique grave (anaphylaxie) pendant le goûter. Facteur de risque : produits faits maison sans liste d'ingrédients, absence d'information des animateurs. Facteur de protection : projet d'accueil individualisé connu de l'équipe, lecture des étiquettes, goûter de l'enfant fourni par la famille, trousse d'urgence disponible.
3. Si l'exposition est nulle (aucun produit contenant de l'arachide n'est consommé), le risque est nul même si le danger existe : risque = danger × exposition.

Corrigé – Exercice 3.2

a) Danger. b) Exposition. c) Risque. d) Facteur de protection. e) Population à risque. f) Facteur de risque. g) Problème de santé. h) Facteur de protection. i) Facteur de risque. j) Facteur de protection.

Corrigé – Exercice 3.3

1. Risque = nouveaux cas / effectif au départ. Boisson sucrée quotidienne : 64 / 400 = 0,16, soit 16 %. Sans boisson sucrée quotidienne : 72 / 800 = 0,09, soit 9 %.
2. Risque relatif = 0,16 / 0,09 = 1,78. Les adolescents qui boivent une boisson sucrée chaque jour ont 1,78 fois plus de risque de devenir en surpoids en 3 ans que les autres.
3. Une association statistique ne prouve pas la causalité : les adolescents qui boivent des boissons sucrées chaque jour peuvent aussi avoir d'autres caractéristiques (sédentarité, temps d'écran, sommeil court, revenus plus faibles, grignotage) qui expliquent une partie de l'écart. Ces facteurs de confusion doivent être pris en compte (chapitre 16).
4. Promotion de la santé : fontaines à eau et suppression de l'offre de boissons sucrées dans les lieux fréquentés par les jeunes (milieux favorables). Éducation pour la santé : atelier sur le sucre caché dans les boissons et fabrication d'eaux aromatisées maison.

Corrigé – Exercice 3.4

1. Danger : Listeria monocytogenes. Exposition : consommation d'aliments pouvant être contaminés (fromages au lait cru, charcuteries à la coupe, poissons fumés, graines germées crues). Risque : probabilité de listériose et de ses complications (fausse couche, prématurité, infection du nouveau-né). Population à risque : les femmes enceintes (ainsi que les personnes âgées et immunodéprimées).
2. La listériose est rare : la plupart des femmes qui consomment ces aliments n'auront pas de listériose, mais celles qui l'ont peuvent avoir des conséquences très graves. L'absence d'accident chez une personne ne prouve pas l'absence de risque : c'est une probabilité, faible, avec une gravité élevée. On ne dramatise pas, on explique.
3. Conseils positifs : « Choisissez les fromages à pâte pressée cuite (comté, emmental) et les fromages pasteurisés » ; « Préférez la charcuterie préemballée et consommez-la rapidement après ouverture » ; « Faites bien cuire viandes et poissons » ; « Nettoyez le réfrigérateur régulièrement et vérifiez sa température (4 °C au plus) » ; « Lavez soigneusement les légumes et les herbes aromatiques ».
4. Prévention primaire (OMS) ; prévention sélective (Gordon), car elle vise un groupe exposé à un risque particulier, sans maladie.

Corrigé – Exercice 3.5

1. Écart absolu = 21 − 15 = 6 points ; rapport = 21 / 15 = 1,4. La prévalence est 1,4 fois plus élevée dans le quartier.

2. Habiter le quartier est associé à une prévalence plus forte, mais ce n'est pas le quartier en lui-même qui cause le surpoids : ce sont des déterminants (revenus, offre alimentaire, espaces d'activité physique, stress, temps disponible) plus fréquents dans le quartier. Confondre association et causalité conduit à des actions inefficaces et stigmatisantes.

3. Facteurs de risque : offre alimentaire limitée (discount, supérette, marché hebdomadaire) ; city-stade fermé, peu d'espaces verts ; chômage et monoparentalité (ressources et temps limités). Facteurs de protection : association de parents active (soutien social, action communautaire) ; jardin partagé ; programme de fruits à la récréation.

4. Exemples : s'appuyer sur l'association de parents pour co-construire des ateliers de cuisine avec les légumes du jardin partagé ; plaider auprès de la mairie pour rouvrir le city-stade avec des animations sportives gratuites ; étendre le programme de fruits à toutes les écoles du quartier.

Corrigé – Exercice 3.6

1. Critères : fréquence (prévalence, incidence), gravité (mortalité, handicap, qualité de vie), évolution et coût, existence de moyens d'action efficaces et faisables, demande et acceptabilité de la population, inégalités. La gravité est pondérée plus fortement, car un problème grave a des conséquences lourdes (décès, perte d'autonomie) même s'il touche moins de personnes.

2. Scores pondérés (fréquence × 2 + gravité × 3 + évolution × 1 + faisabilité × 2 + demande × 1) : surpoids des enfants : 3 × 2 + 2 × 3 + 2 × 1 + 2 × 2 + 2 × 1 = 20 ; dénutrition des seniors : 2 × 2 + 3 × 3 + 2 × 1 + 3 × 2 + 1 × 1 = 22 ; insécurité alimentaire : 3 × 2 + 2 × 3 + 2 × 1 + 2 × 2 + 3 × 1 = 21 ; légumineuses : 3 × 2 + 1 × 3 + 1 × 1 + 3 × 2 + 1 × 1 = 17. Classement : dénutrition des seniors (22), insécurité alimentaire (21), surpoids des enfants (20), légumineuses (17).

3. Les trois premiers scores sont très proches (22, 21, 20) : un point de différence sur une seule note changerait le classement. Les notes sont subjectives et doivent être justifiées par des données (prévalences, demandes recueillies). La dénutrition touche moins de personnes, mais sa gravité (chutes, hospitalisations, perte d'autonomie) explique son rang. Le groupe peut aussi chercher une action qui répond à deux problèmes à la fois (par exemple l'insécurité alimentaire des seniors isolés).

4. Recommandation : « La grille place en tête la dénutrition des seniors à domicile (22 points), suivie de près par l'insécurité alimentaire des familles (21) et le surpoids des enfants (20). Nous recommandons une action de repérage et de prévention de la dénutrition, avec le portage de repas, le CCAS et les infirmiers libéraux, car le problème est grave et des moyens efficaces existent. Les scores étant proches, l'insécurité alimentaire sera traitée en 2028 ; les notes seront révisées avec les données du diagnostic. »

Partie 4 – Les modes d'intervention en santé publique

Objectifs – Objectifs de la partie

- Nommer et distinguer les quatre modes d'intervention : surveillance et veille, promotion de la santé, prévention, éducation pour la santé.
- Classer une action selon les niveaux de prévention de l'OMS et selon Gordon.
- Citer les 5 domaines d'action et les 3 stratégies de la Charte d'Ottawa et les illustrer en nutrition.
- Appliquer l'universalisme proportionné ; choisir une approche éducative participative et non stigmatisante.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Prévention primaire : avant la maladie, réduit l'incidence. Secondaire : maladie débutante, réduit la prévalence (dépistage). Tertiaire : maladie installée, réduit les complications et les récidives (ETP). Quaternaire (Jamoulle, 1986) : éviter la surmédicalisation.
- Gordon (1983) : universelle (toute la population), sélective (groupe à risque sans signe), indiquée (personnes présentant des facteurs de risque ou des signes).
- Charte d'Ottawa (21 novembre 1986) : 5 domaines (politique publique saine, milieux favorables, action communautaire, aptitudes individuelles, réorientation des services de santé) et 3 stratégies (plaider, conférer les moyens, servir de médiateur).
- Universalisme proportionné (Marmot, 2010) : action pour tous, intensité proportionnelle au désavantage.
- Éducation pour la santé : nutritionnelle, alimentaire, sensorielle ; approches informative, persuasive, participative.

Exercice 4.1 – Légender les niveaux de prévention (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous devez présenter, en réunion d'équipe d'une PMI, les classifications de la prévention pour qualifier les actions du service.

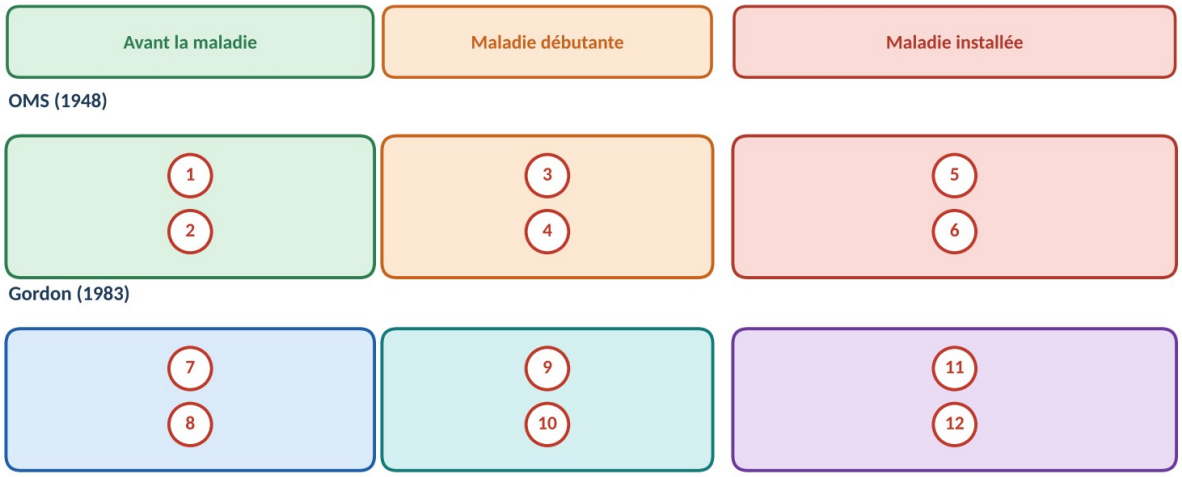


Figure 4.1 – Document 1 – Les niveaux de prévention selon l'OMS et selon Gordon (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (6 pts)
2. Pour chacun des trois niveaux de l'OMS, donnez un exemple d'action en nutrition. (3 pts)
3. Définissez la prévention quaternaire et donnez un exemple en nutrition. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.2 – Les 5 domaines et les 3 stratégies de la Charte d'Ottawa (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une ville de 25 000 habitants (structure fictive) a signé la charte « Ville active du PNNS ». Vous devez montrer aux élus que leur plan d'action couvre bien les cinq domaines de la Charte d'Ottawa.

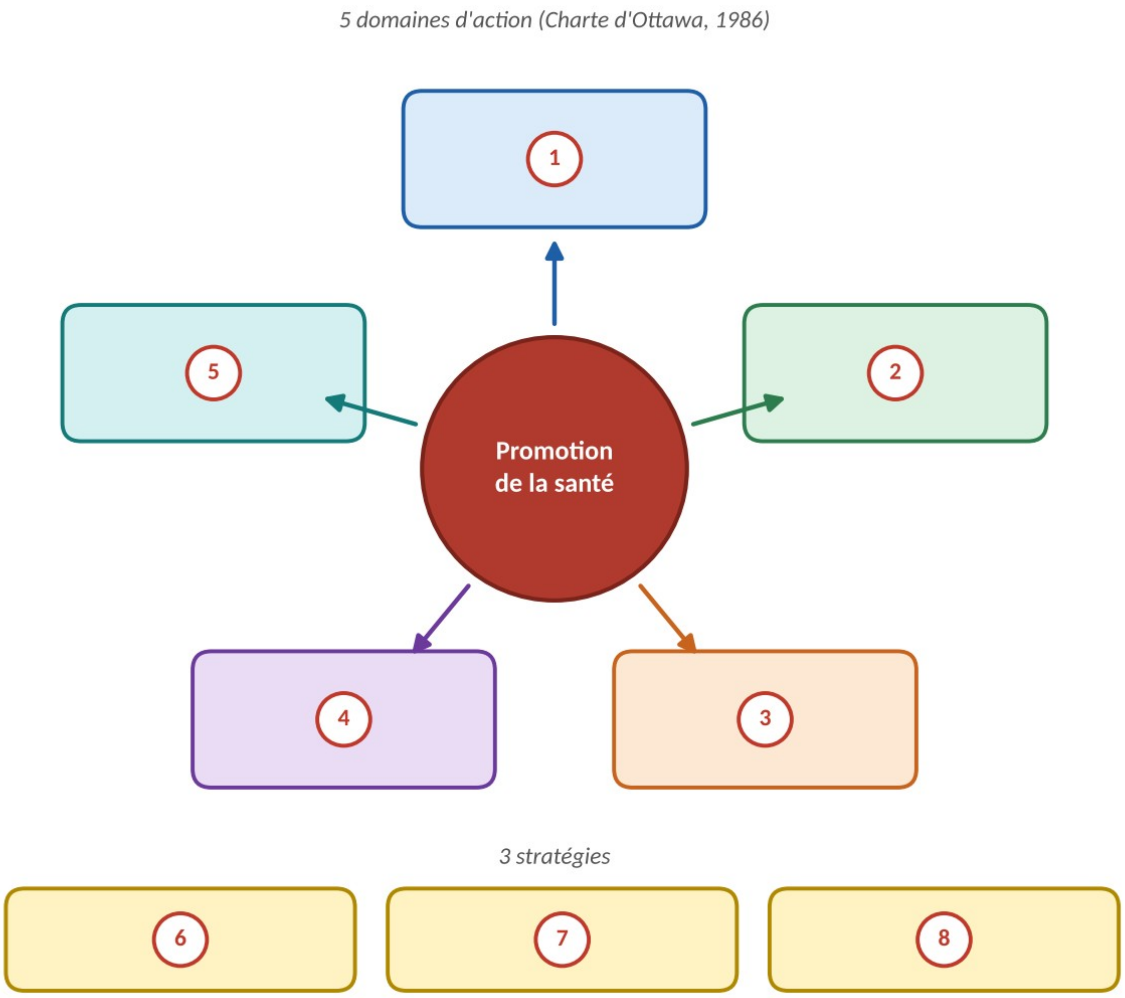


Figure 4.2 – Document 1 – La Charte d'Ottawa (schéma à légender)

Document 2 – Actions du plan municipal

a) Fontaines à eau dans toutes les écoles. b) Ateliers « cuisine du marché » pour les habitants. c) Jardin partagé géré par une association d'habitants. d) Délibération du conseil municipal fixant 50 % de produits durables dont 20 % de bio en restauration scolaire. e) Consultation de prévention nutritionnelle à la maison de santé. f) Rencontres entre maraîchers, cuisine centrale et parents d'élèves pour choisir les produits. g) Formation des animateurs périscolaires à l'éducation au goût. h) Présentation aux élus des données de corpulence des enfants pour obtenir le financement.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés du document 1. (4 pts)

2. Classez chaque action du document 2 dans un domaine d'action de la Charte. (5 pts)
3. Associez les actions f et h à une des trois stratégies ; justifiez. (2 pts)
4. Rappelez la définition de la promotion de la santé selon la Charte d'Ottawa. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.3 – Qualifier une action (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Document 1 – Six actions observées sur un territoire

a) Une campagne nationale de radio rappelle les repères du PNNS.

b) La santé scolaire mesure le poids et la taille des élèves de grande section et oriente les enfants dont la courbe de corpulence remonte tôt.

c) Une diététicienne anime 6 ateliers « petit budget » pour les familles bénéficiaires d'une épicerie sociale.

d) Un service de diabétologie organise un programme d'éducation thérapeutique déclaré à l'ARS.

e) Santé publique France publie les résultats d'une enquête nationale sur la corpulence.

f) Un EHPAD pèse chaque résident à l'entrée puis tous les mois et dose l'albumine sur prescription.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque action, indiquez le mode d'intervention, le niveau de prévention (OMS) et le type (Gordon), quand c'est possible. (9 pts)
2. Expliquez pourquoi l'action d ne relève pas de l'éducation pour la santé. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.4 – Appliquer l'universalisme proportionné à la cantine (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et argumentation · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une commune (données fictives) facture actuellement le repas de cantine 3,00 € à toutes les familles. Elle étudie une tarification sociale en quatre tranches selon le quotient familial. Un enfant mange 140 repas par an à la cantine.

Document 1 – Tarification étudiée et revenus types

Tranche	Revenu mensuel type de la famille	Prix du repas proposé
Tranche 1	1 300 €	1,00 €
Tranche 2	2 200 €	2,20 €
Tranche 3	3 400 €	3,40 €
Tranche 4	5 500 €	4,50 €

À vous de jouer – Questions

1. Définissez l'universalisme proportionné et citez son auteur. (2 pts)
2. Calculez, pour chaque tranche, le coût annuel de la cantine et sa part dans le revenu annuel, avec le tarif unique de 3,00 € puis avec la tarification proposée. (6 pts)
3. Interprétez les résultats : quelle tarification est la plus équitable ? (3 pts)
4. Montrez que la tarification sociale est une action universelle d'intensité proportionnée ; proposez une autre mesure qui renforce l'accès des familles de la tranche 1. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.5 – Choisir une approche éducative (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse critique · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un collège veut agir sur la consommation de boissons sucrées des élèves de 5e. Trois propositions sont faites.

Document 1 – Trois propositions

Proposition 1 : une affiche montrant un adolescent en surpoids avec le slogan « Le soda, c'est ça qui t'attend ».

Proposition 2 : un dépliant indiquant la quantité de sucre de 10 boissons et les repères du PNNS.

Proposition 3 : trois séances où les élèves mesurent le sucre de leurs boissons préférées, inventent des recettes d'eaux aromatisées, les font goûter aux autres classes et proposent au conseil d'administration l'installation d'une fontaine.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez l'approche éducative de chaque proposition et indiquez sa principale limite ou son principal intérêt. (6 pts)
2. Réécrivez le slogan de la proposition 1 pour qu'il soit positif et non stigmatisant. (2 pts)
3. Montrez que la proposition 3 combine plusieurs domaines de la Charte d'Ottawa et développe des compétences psychosociales. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.6 – Construire une réponse combinant les quatre modes (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mutuelle régionale (structure fictive) vous recrute en stage. Elle veut un programme « Bien manger au travail » pour les 1 200 salariés de ses adhérents entreprises, et un programme pour ses adhérents atteints de diabète de type 2. Le directeur pense « faire la même chose pour tout le monde, avec une conférence et un livret ».

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez au directeur pourquoi les deux publics relèvent de modes d'intervention différents. (4 pts)
2. Proposez, pour les salariés, une action relevant de chacun des quatre modes d'intervention (surveillance et veille, promotion de la santé, prévention, éducation pour la santé). (6 pts)
3. Indiquez, pour les adhérents diabétiques, le cadre réglementaire de l'éducation thérapeutique et le rôle possible du diététicien. (3 pts)
4. Critiquez l'idée d'une conférence et d'un livret identiques pour tous, en citant deux principes de la promotion de la santé. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 4.1

1. Légendes : 1 Prévention primaire ; 2 réduit l'incidence ; 3 Prévention secondaire ; 4 réduit la prévalence ; 5 Prévention tertiaire ; 6 réduit les complications et récidives ; 7 Universelle ; 8 toute la population ; 9 Sélective ; 10 groupe à risque, sans signe ; 11 Indiquée ; 12 personnes présentant des signes.
2. Primaire : atelier cuisine, repères du PNNS, réduction du sel dans le pain. Secondaire : dépistage de la dénutrition à l'entrée en EHPAD, repérage du rebond d'adiposité précoce. Tertiaire : prise en charge diététique d'un diabète, ETP.
3. La prévention quaternaire (Marc Jamoulle, 1986) protège les personnes de la surmédicalisation et des interventions inutiles ou nocives. Exemple : éviter un régime d'exclusion du gluten sans diagnostic de maladie cœliaque, ou des compléments alimentaires inutiles.

Corrigé – Exercice 4.2

1. Légendes : 1 Élaborer une politique publique saine ; 2 Créer des milieux favorables ; 3 Renforcer l'action communautaire ; 4 Acquérir des aptitudes individuelles ; 5 Réorienter les services de santé ; 6 Plaider ; 7 Conférer les moyens ; 8 Servir de médiateur.
2. a) Milieux favorables. b) Aptitudes individuelles. c) Action communautaire. d) Politique publique saine. e) Réorientation des services de santé. f) Action communautaire (et politique publique). g) Aptitudes individuelles (des professionnels relais) et réorientation des services. h) Politique publique saine, par le plaidoyer.
3. f : servir de médiateur, car on concilie les intérêts des producteurs, de la cuisine et des familles. h : plaider, car on présente des données aux décideurs pour obtenir une décision et des moyens.
4. « La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer celle-ci. »

Corrigé – Exercice 4.3

1. a) Éducation pour la santé informative et prévention primaire universelle. b) Prévention secondaire (repérage précoce), type indiqué, car les enfants repérés présentent un signe ; elle s'appuie sur la surveillance. c) Éducation pour la santé (alimentaire) et prévention primaire sélective. d) Éducation thérapeutique du patient : soin et prévention tertiaire. e) Surveillance épidémiologique (pas de niveau de prévention : elle produit les données). f) Prévention secondaire : dépistage de la dénutrition.
2. L'ETP s'adresse à des patients atteints d'une maladie chronique, pour les aider à gérer leur maladie et leur traitement ; elle relève du soin, est encadrée par l'article L. 1161-1 du code de la santé publique (loi HPST du 21 juillet 2009) et se fait dans des programmes déclarés à l'ARS. L'éducation pour la santé vise des personnes bien portantes.

Corrigé – Exercice 4.4

1. Universalisme proportionné (Michael Marmot, 2010) : les actions sont destinées à toute la population, mais leur intensité augmente avec le niveau de désavantage social.
2. Coût annuel = 140 × prix ; revenu annuel = revenu mensuel × 12 ; part = coût / revenu annuel × 100.

Tranche	Revenu annuel	Tarif unique : coût	Tarif unique : part du revenu	Tarif proposé : coût	Tarif proposé : part du revenu
1	15 600 €	420 €	2,69 %	140 €	0,90 %
2	26 400 €	420 €	1,59 %	308 €	1,17 %
3	40 800 €	420 €	1,03 %	476 €	1,17 %
4	66 000 €	420 €	0,64 %	630 €	0,95 %

3. Avec le tarif unique, l'effort demandé est 4 fois plus lourd pour la tranche 1 (2,69 %) que pour la tranche 4 (0,64 %) : 2,69 / 0,64 = 4,2. Avec la tarification proposée, l'effort est proche pour toutes les familles (de 0,90 % à 1,17 %). La tarification sociale est plus équitable : elle réduit le frein financier pour les familles modestes.

4. La cantine reste ouverte à tous (universelle), mais l'aide est plus forte pour les familles les plus modestes (intensité proportionnée). Mesure complémentaire : information des familles et inscription simplifiée par le CCAS, petit-déjeuner à l'école dans les quartiers prioritaires, ou aide aux repas des vacances scolaires.

Corrigé – Exercice 4.5

1. Proposition 1 : approche persuasive par la peur ; elle culpabilise, stigmatise les adolescents en surpoids et peut renforcer les inégalités. Proposition 2 : approche informative ; utile, mais savoir ne suffit pas à changer un comportement. Proposition 3 : approche participative ; elle part des élèves, développe leurs compétences et leur pouvoir d'agir, mais demande du temps et des compétences d'animation.

2. Exemple : « L'eau, ça se personnalise : invente ta boisson ! » ou « Envie de fraîcheur ? Teste nos eaux aux fruits. »

3. Domaines d'Ottawa : aptitudes individuelles (mesurer le sucre, cuisiner), action communautaire (élèves acteurs auprès des autres classes), milieux favorables et politique de l'établissement (fontaine votée au conseil d'administration). Compétences psychosociales : pensée critique (analyse des boissons et de la publicité), créativité (recettes), communication et coopération (présentation aux autres classes), prise de décision (proposition au conseil d'administration).

Corrigé – Exercice 4.6

1. Les salariés sont des personnes a priori bien portantes : l'action relève de la promotion de la santé, de la prévention primaire et de l'éducation pour la santé. Les adhérents diabétiques sont des patients : l'accompagnement de leur maladie relève de l'éducation thérapeutique, donc du soin et de la prévention tertiaire, avec des objectifs, des méthodes et un cadre différents.

2. Surveillance et veille : questionnaire anonyme sur les habitudes alimentaires au travail, suivi des données de la restauration ; veille sur les recommandations. Promotion de la santé : amélioration de l'offre de la restauration d'entreprise et des distributeurs, pauses repas protégées, espaces pour déjeuner. Prévention : dépistage proposé du risque cardiovasculaire lors d'une journée santé, avec orientation vers le médecin (prévention secondaire), ou action sur le sel (primaire). Éducation pour la santé : ateliers « gamelle équilibrée », lecture d'étiquettes, défis collectifs.

3. Cadre : article L. 1161-1 du code de la santé publique (loi HPST du 21 juillet 2009), recommandations de la HAS (2007), programmes déclarés à l'ARS. Le diététicien formé à l'ETP peut participer au bilan éducatif partagé et animer des séances (adapter son alimentation, lire les étiquettes, gérer les repas à l'extérieur).

4. Une conférence et un livret pour tous relèvent d'une approche informative, peu efficace seule ; ils ne partent pas des besoins de chaque public. Principes à citer : participation des personnes concernées dès le diagnostic ; action sur les milieux et pas seulement sur les comportements ; universalisme proportionné ; non-stigmatisation.

Partie 5 – Les acteurs et les organismes de la santé publique en nutrition

Objectifs – Objectifs de la partie

- Situer les acteurs aux niveaux international, européen, national, régional et local, et citer leur rôle en nutrition.
- Trouver la bonne source de données pour un diagnostic.
- Construire un plan de financement et une carte des partenaires d'un projet.
- Repérer les conflits d'intérêts dans un outil ou un partenariat.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Santé publique France (créée le 1er mai 2016) : surveillance, veille et alerte, prévention et promotion de la santé, « Manger Bouger », Nutri-Score, ESTEBAN, Géodes.
- ANSES (2010) : évaluation des risques, références nutritionnelles, études INCA, table Ciqual, Oqali, nutrivigilance.
- HAS (2004) : recommandations de bonne pratique, ETP. HCSP (2004) : expertise et avis (repères alimentaires, recommandations pour le PNNS 5). CNA (1985) : concertation.
- DGS (ministère chargé de la santé) : pilote le PNNS. DGAL (ministère chargé de l'agriculture) : pilote le PNA, sécurité sanitaire des aliments. DGCCRF : loyauté, étiquetage.
- ARS (loi HPST du 21 juillet 2009, créées en 2010) : projet régional de santé, financement de la prévention, contrats locaux de santé. DRAAF : PNA en région, projets alimentaires territoriaux.

Exercice 5.1 – Légender la carte des acteurs (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dès la première semaine de stage, votre tutrice vous demande d'établir la carte des acteurs qui interviennent en nutrition, du niveau international au niveau local.

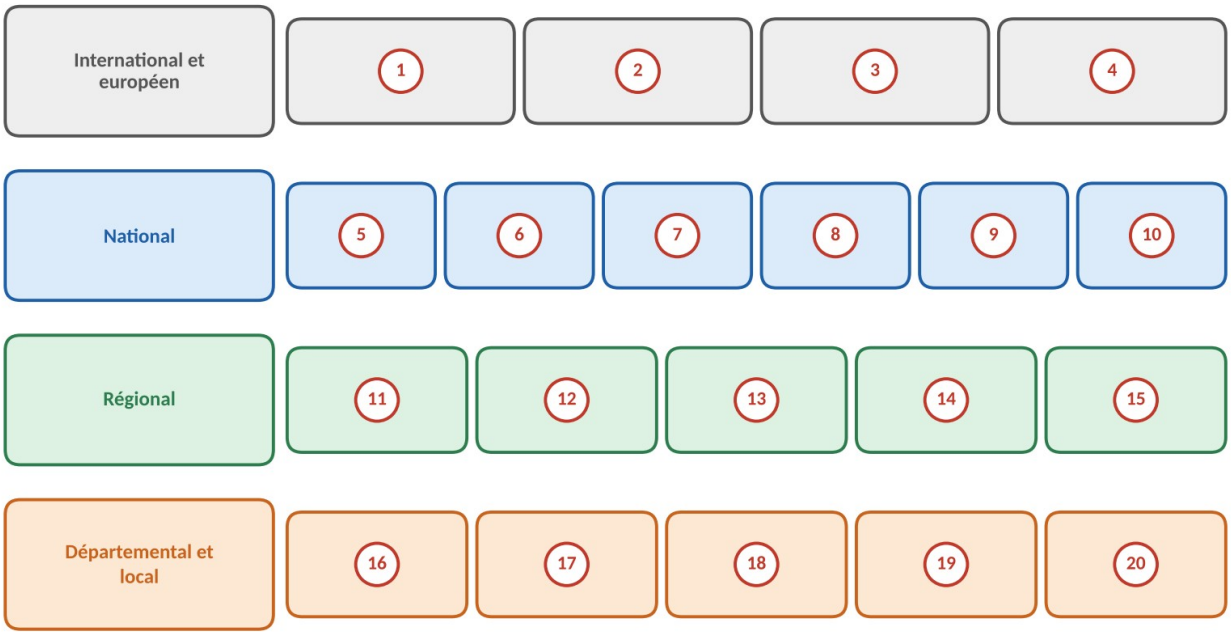


Figure 5.1 – Document 1 – Les acteurs de la santé publique en nutrition (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les cases 1 à 20 du document 1, sachant que : la ligne 1 comprend deux agences des Nations unies, l'autorité européenne d'évaluation des risques et l'institution qui propose la réglementation européenne ; la ligne 2 comprend la direction qui pilote le PNNS, deux agences sanitaires, deux instances d'expertise et la direction qui pilote la sécurité sanitaire des aliments ; la ligne 3 comprend l'agence qui pilote la santé en région, la collectivité qui gère les lycées, le service de l'État chargé de l'alimentation en région, l'observatoire et la structure d'appui méthodologique ; la ligne 4 comprend les acteurs de proximité. (10 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.2 – Qui fait quoi ? (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Document 1 – Dix missions

a) Publier les références nutritionnelles et réaliser les études INCA. b) Gérer en France le logo Nutri-Score et le programme « Manger Bouger ». c) Publier une recommandation de bonne pratique sur la dénutrition. d) Rendre un avis d'expertise sur les repères alimentaires des enfants. e) Réunir producteurs, distributeurs, consommateurs et professionnels de santé pour rendre des avis. f) Contrôler la loyauté de l'étiquetage d'un produit. g) Évaluer les risques alimentaires au niveau européen. h) Signer un contrat local de santé avec une commune. i) Reconnaître un projet alimentaire territorial. j) Piloter le programme national pour l'alimentation.

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque mission à l'organisme qui en est chargé. (10 × 1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.3 – Trouver la bonne source de données (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – méthode · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez le diagnostic d'un projet « Bien manger, bien grandir » dans une communauté d'agglomération. Vous devez trouver des données nationales de comparaison et des données locales.

Document 1 – Données recherchées

a) Prévalence de l'obésité mesurée chez les adultes en France. b) Consommations alimentaires détaillées des enfants et des adultes. c) Part de la population sous le seuil de pauvreté dans l'agglomération. d) Causes médicales de décès dans le département. e) Corpulence des élèves de grande section, de CM2 et de 3e. f) Composition nutritionnelle des aliments servis à la cantine. g) Indicateurs de santé déjà rassemblés pour le territoire. h) Données de santé consultables en ligne et cartographiées.

À vous de jouer – Questions

1. Indiquez, pour chaque donnée, une source et l'organisme qui la produit. (8 pts)

2. Expliquez pourquoi ESTEBAN (2014-2016) reste citée en 2026 et ce que changera l'enquête Albane. (2 pts)

3. Indiquez trois règles pour citer une donnée dans un dossier E5. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.4 – Construire un plan de financement (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et méthode · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre social (structure fictive) prépare un projet d'ateliers « Cuisine et budget » pour 40 familles sur un an. Le budget total est de 12 400 €. Vous devez compléter le plan de financement à joindre aux demandes de subvention.

Document 1 – Financements obtenus ou demandés

Financeur	Montant
ARS (appel à projets prévention)	5 000 €
Commune (au titre du contrat local de santé)	3 000 €
CAF	2 500 €
DREETS (programme « Mieux manger pour tous »)	1 400 €
Fonds propres du centre social	500 €

À vous de jouer – Questions

1. Vérifiez que le plan de financement est équilibré et calculez la part de chaque financeur. (4 pts)

2. Justifiez la légitimité de chaque financeur pour ce projet. (5 pts)

3. Indiquez ce que le centre social devra fournir à ses financeurs en fin de projet. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.5 – Repérer un conflit d'intérêts (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse critique · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une entreprise de produits laitiers sucrés propose gratuitement à une école un « kit pédagogique sur le petit-déjeuner », avec des affiches, un jeu et des échantillons de ses produits. La directrice vous demande votre avis.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez un conflit d'intérêts et expliquez pourquoi ce kit en présente un. (3 pts)
2. Proposez cinq critères pour évaluer la qualité d'un outil pédagogique en nutrition. (5 pts)
3. Indiquez où trouver des outils pédagogiques validés et sans lien commercial. (2 pts)
4. Rédigez la réponse à la directrice en 4 lignes. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.6 – Construire la carte des partenaires d'un projet (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au service développement durable d'une communauté de communes rurale (structure fictive) qui porte un projet alimentaire territorial. Le projet veut augmenter la part de produits locaux dans les 6 cantines du territoire et créer des ateliers cuisine pour les familles. Vous devez identifier les partenaires et leur rôle.

Document 1 – Acteurs rencontrés

Élus de la communauté de communes ; cuisinières des 6 cantines ; parents d'élèves ; chambre d'agriculture ; 12 maraîchers et éleveurs ; DRAAF ; ARS (délégation départementale) ; enseignants ; centre social ; épicerie sociale ; association de jardiniers ; supermarché du bourg.

À vous de jouer – Questions

1. Classez les acteurs dans une matrice « pouvoir de décision / intérêt pour le projet » (quatre cases) ; indiquez la stratégie d'implication pour chaque case. (6 pts)
2. Précisez le rôle attendu de la DRAAF, de l'ARS et de la chambre d'agriculture. (3 pts)
3. Proposez une instance de pilotage et sa composition. (3 pts)
4. Montrez que le projet est intersectoriel et qu'il s'inscrit dans l'approche « Une seule santé ». (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 5.1

Ligne 1 : 1 OMS ; 2 FAO ; 3 EFSA ; 4 Commission européenne. Ligne 2 : 5 Ministère chargé de la santé (DGS) ; 6 Santé publique France ; 7 ANSES ; 8 HAS ; 9 HCSP ; 10 Ministère chargé de l'agriculture (DGAL). Ligne 3 : 11 ARS ; 12 Conseil régional ; 13 DRAAF ; 14 ORS ; 15 Promotion Santé (ex-IREPS). Ligne 4 : 16 Conseil départemental (PMI) ; 17 Communes et CCAS ; 18 Éducation nationale ; 19 CPTS, maisons de santé ; 20 Associations. L'ordre des cases d'une même ligne n'est pas exigé si les acteurs sont justes.

Corrigé – Exercice 5.2

a) ANSES. b) Santé publique France. c) HAS (avec la FFN pour la dénutrition de la personne âgée, 2021). d) HCSP (avis de 2020 sur les repères des enfants). e) CNA. f) DGCCRF. g) EFSA. h) ARS. i) DRAAF (ministère chargé de l'agriculture). j) DGAL (ministère chargé de l'agriculture).

Corrigé – Exercice 5.3

1. a) ESTEBAN, Santé publique France (2014-2016 : 17 % d'obésité chez les 18-74 ans). b) INCA 3, ANSES (2014-2015). c) Insee (taux de pauvreté, données locales). d) CépiDc de l'Inserm (causes médicales de décès). e) Enquêtes de santé scolaire, Drees. f) Table Ciqual, ANSES. g) ORS (portraits de territoire) ou diagnostic du contrat local de santé. h) Géodes, Santé publique France.
2. ESTEBAN fournit les dernières données de corpulence mesurée (et non déclarée) en population générale. L'enquête Albane, lancée en 2025 par Santé publique France et l'ANSES, associera régulièrement questionnaires, mesures et examens : elle remplacera ESTEBAN et INCA pour suivre l'état nutritionnel.
3. Citer l'organisme, le titre de l'étude et l'année de recueil ; vérifier que c'est la donnée la plus récente ; distinguer donnée mesurée et déclarée ; préciser le champ (âge, territoire).

Corrigé – Exercice 5.4

1. Total = 5 000 + 3 000 + 2 500 + 1 400 + 500 = 12 400 € : le plan est équilibré. Parts (montant / 12 400 × 100) : ARS 40,3 % ; commune 24,2 % ; CAF 20,2 % ; DREETS 11,3 % ; fonds propres 4,0 %.
2. ARS : finance la prévention et la promotion de la santé (fonds d'intervention régional), en lien avec le projet régional de santé. Commune : porteuse du contrat local de santé et de l'action sociale (CCAS). CAF : finance les centres sociaux et le soutien aux familles. DREETS : programme « Mieux manger pour tous » (aide alimentaire de qualité). Fonds propres : montrent l'engagement du porteur.
3. Bilan d'activité (actions réalisées, participants), bilan d'évaluation (indicateurs de résultats), bilan financier (dépenses réelles justifiées), supports produits, perspectives.

Corrigé – Exercice 5.5

1. Un conflit d'intérêts existe quand un intérêt secondaire (ici commercial : vendre des produits laitiers sucrés) peut influencer un objectif principal (l'éducation des enfants). Le kit fait la promotion de la marque et risque de présenter ses produits comme indispensables au petit-déjeuner.
2. Critères : auteur identifié et indépendant, sans lien commercial ; contenu exact et à jour (repères du PNNS) ; adapté à l'âge et à la culture du public ; démarche participative, non culpabilisante ; objectifs pédagogiques explicites ; évalué ou testé ; absence de marque et de publicité.
3. Pédagothèques et centres de ressources des structures régionales Promotion Santé, outils de Santé publique France (mangerbouger.fr), outils de l'Éducation nationale (Éduscol).
4. « Ce kit est fourni par une entreprise qui vend les produits présentés : il présente un conflit d'intérêts et ne doit pas être utilisé, en particulier les échantillons. Je vous propose des outils indépendants des pédagothèques de Promotion Santé et de Santé publique France, que je peux adapter avec les

enseignants. »

Corrigé – Exercice 5.6

1. Matrice : pouvoir fort et intérêt fort (élus, DRAAF financeur du PAT) : associer étroitement, co-décider. Pouvoir fort et intérêt plus faible (ARS, supermarché du bourg) : tenir informés, solliciter sur des points précis. Pouvoir faible et intérêt fort (cuisinières, parents, maraîchers et éleveurs, centre social, épicerie sociale, association de jardiniers, enseignants) : faire participer aux groupes de travail. Pouvoir faible et intérêt faible : informer régulièrement. Le classement se discute ; l'important est de le justifier.

2. DRAAF : reconnaissance du PAT et financements du programme national pour l'alimentation. ARS : volet santé (financement d'ateliers, lien avec le contrat local de santé). Chambre d'agriculture : mise en relation avec les producteurs, structuration de l'offre locale.

3. Comité de pilotage présidé par l'élu référent : élus, DRAAF, ARS, chambre d'agriculture, représentant des cuisinières, représentant des parents, producteurs, centre social ; réunion 2 fois par an ; groupes de travail thématiques.

4. Intersectoriel : agriculture, éducation, santé, social, économie locale, environnement. « Une seule santé » : santé humaine (qualité des repas), santé des écosystèmes (produits de saison, circuits courts, moins de transport, agriculture durable), santé animale (conditions d'élevage des éleveurs locaux).

Partie 6 – Les politiques publiques de santé et leur déclinaison territoriale

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir une politique publique et distinguer loi, règlement, stratégie, plan et financement.
- Décrire les étapes d'une politique publique, de la mise à l'agenda à l'évaluation.
- Expliquer l'architecture SNS, PRS (COS, SRS, PRAPS), CLS, et situer le PAT et le contrat de ville.
- Relier une action locale aux politiques nationales et régionales ; répondre à un appel à projets.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Stratégie nationale de santé (article L. 1411-1-1 du code de la santé publique) : dernière adoptée 2018-2022 ; projet 2023-2033 non adopté en mai 2026.
- Projet régional de santé (article L. 1434-1) élaboré par l'ARS : cadre d'orientation stratégique sur 10 ans, schéma régional de santé sur 5 ans, PRAPS (programme régional d'accès à la prévention et aux soins des plus démunis).
- Contrat local de santé (article L. 1434-10) : contrat entre l'ARS et une collectivité pour mettre en œuvre le PRS au plus près des habitants.
- Projet alimentaire territorial : loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014 ; reconnu par le ministère chargé de l'agriculture.
- Étapes : mise à l'agenda, élaboration, décision, mise en œuvre, pilotage et suivi, évaluation.

Exercice 6.1 – Légender l'architecture de la politique régionale de santé (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez la partie « contexte » de votre dossier E5 et voulez montrer au jury comment votre action locale s'inscrit dans la politique de santé.

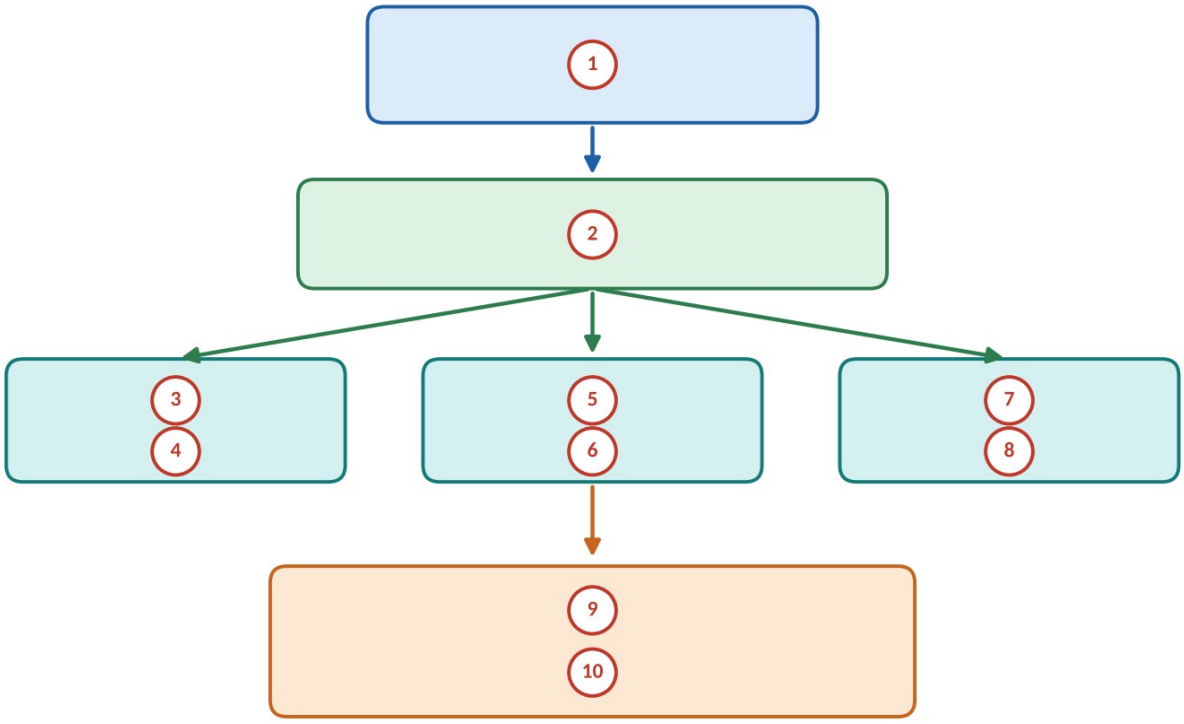


Figure 6.1 – Document 1 – De la stratégie nationale au contrat local de santé (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés du document 1. (5 pts)

2. Expliquez le rôle du PRAPS pour un projet auprès de personnes en situation de précarité. (2 pts)

3. Indiquez où trouver le PRS de votre région et le contrat local de santé de votre lieu de stage. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.2 – Reconnaître les outils d'une politique publique (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Document 1 – Dix textes et dispositifs

a) Loi EGalim du 30 octobre 2018. b) Arrêté du 14 mars 2025 sur le Nutri-Score. c) Projet de stratégie nationale de santé 2023-2033. d) PNNS 5 (2026-2030). e) Fonds d'intervention régional des ARS. f) SNANC 2025-2030. g) Décret du 30 septembre 2011 sur la qualité nutritionnelle des repas scolaires. h) Loi Climat et résilience du 22 août 2021. i) Programme « Mieux manger pour tous ». j) PNA 4 (2026-2030).

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque élément : loi, règlement (décret ou arrêté), stratégie, plan ou programme, financement. (10 × 1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.3 – Les étapes d'une politique publique : l'exemple du PNNS 5 (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Document 1 – Événements dans le désordre

a) Le HCSP publie en juin 2025 ses recommandations pour le futur programme. b) Les ARS financent en région des actions qui déclinent le programme. c) Les données de surveillance montrent depuis les années 1990 une hausse du surpoids des enfants et un fort gradient social. d) Le programme est présenté le 8 avril 2026. e) Un comité de suivi examine chaque année des indicateurs (part des produits affichant le Nutri-Score, allaitement à la naissance). f) Une évaluation indépendante du programme préparera le PNNS suivant. g) Le PNNS 4 (2019-2023) est évalué, et une concertation réunit ARS, associations et chercheurs.

À vous de jouer – Questions

1. Remettez les événements dans l'ordre des étapes d'une politique publique, en nommant chaque étape. (7 pts)
2. Citez trois instances capables d'évaluer une politique de santé. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi l'évaluation est le début du cycle suivant. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.4 – Analyser une fiche-action de contrat local de santé (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice coordonne le contrat local de santé d'une intercommunalité (structure fictive). Elle vous demande de relire une fiche-action avant le comité de pilotage.

Document 1 – Fiche-action n° 4 « Bien manger à tout âge » (extrait)

Constat : « Les habitants mangent mal. » Objectif : « Sensibiliser la population à l'alimentation. » Actions : conférences dans les mairies ; distribution de dépliants ; un stand au forum des associations. Porteur : à définir. Partenaires : tous. Budget : à voir. Indicateurs : « nombre de personnes sensibilisées ». Calendrier : 2025-2028.

À vous de jouer – Questions

1. Relevez quatre faiblesses de la fiche-action. (4 pts)
2. Réécrivez le constat et l'objectif à partir de données de diagnostic que vous inventerez de façon réaliste (en les signalant comme fictives). (4 pts)
3. Proposez trois indicateurs (processus, résultat, satisfaction) avec une valeur cible. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.5 – Relier une action locale aux politiques (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – méthode · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pendant votre stage dans une PMI d'un département (structure fictive), vous animez des ateliers « premiers repas de bébé » pour des parents en situation de précarité.

À vous de jouer – Questions

1. Reliez cette action à chacun des niveaux suivants, en citant un texte ou un dispositif précis : international, national (stratégie), national (programme), régional, local. (6 pts)
2. Rédigez la phrase d'inscription du projet dans les politiques, telle qu'elle figurera dans votre dossier. (3 pts)
3. Indiquez les sources que le jury attend pour ces références et la vérification à faire avant de les citer. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.6 – Répondre à un appel à projets de l'ARS (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association d'aide à domicile (structure fictive) veut répondre à l'appel à projets « Prévention et promotion de la santé » de l'ARS pour prévenir la dénutrition des personnes âgées qu'elle accompagne. Elle suit 420 personnes de 75 ans et plus ; un repérage fait par les aides à domicile a montré que 63 d'entre elles ont perdu du poids récemment selon leurs proches.

Document 1 – Budget prévisionnel envisagé

Formation des 30 aides à domicile au repérage (2 sessions × 650 €) ; ateliers « repas plaisir » en petits groupes (12 ateliers × 180 €) ; balances pour le suivi du poids (15 × 40 €) ; livret pour les aidants (420 exemplaires × 1,50 €) ; coordination par une diététicienne (60 heures × 35 €).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part des personnes repérées et indiquez la limite de ce repérage. (2 pts)
2. Calculez le budget total et la part de chaque poste. (4 pts)
3. Montrez l'inscription du projet dans les politiques en vigueur (PNNS 5, PRS, recommandations de la HAS). (3 pts)
4. Formulez l'objectif général et deux objectifs spécifiques. (4 pts)
5. Indiquez les engagements éthiques du projet (consentement, données de poids, non-stigmatisation). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 6.1

1. Légendes : 1 Stratégie nationale de santé ; 2 Projet régional de santé (élaboré par l'ARS) ; 3 Cadre d'orientation stratégique ; 4 10 ans ; 5 Schéma régional de santé ; 6 5 ans ; 7 PRAPS (plus démunis) ; 8 5 ans ; 9 Contrat local de santé ; 10 ARS + collectivité (article L. 1434-10 du CSP).
2. Le PRAPS fixe les actions régionales pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies : un projet auprès d'un public précaire peut s'y référer pour justifier sa priorité et demander un financement.
3. PRS : site internet de l'ARS de la région (rubrique « Projet régional de santé »). CLS : site de l'ARS ou de la collectivité, ou demande auprès du coordinateur du CLS ; vérifier les dates de validité.

Corrigé – Exercice 6.2

Loi : a, h. Règlement : b (arrêté), g (décret). Stratégie : c (encore à l'état de projet en mai 2026), f. Plan ou programme : d, j. Financement : e, i (programme de financement de l'aide alimentaire).

Corrigé – Exercice 6.3

1. Ordre : c) mise à l'agenda (des données font du problème un problème public) ; g) puis a) élaboration (évaluation du programme précédent, concertation, expertise du HCSP) ; d) décision et adoption ; b) mise en œuvre ; e) pilotage et suivi ; f) évaluation.
2. HCSP, IGAS, Cour des comptes (et des équipes de recherche indépendantes).
3. L'évaluation mesure ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné ; ses conclusions servent de diagnostic pour le programme suivant : c'est un cycle d'amélioration continue.

Corrigé – Exercice 6.4

1. Faiblesses : constat vague et jugeant, sans donnée chiffrée ni source ; objectif non mesurable et sans échéance ; actions uniquement informatives (conférences, dépliants), peu efficaces seules ; porteur, partenaires et budget non définis ; indicateur imprécis ; aucun public prioritaire.
2. Exemple (données fictives) : constat : « Dans l'intercommunalité, 19 % des élèves de CM2 sont en surpoids (contre 15 % dans le département, santé scolaire 2025) et 42 % des seniors de plus de 75 ans vivent seuls (Insee). » Objectif : « D'ici fin 2028, faire participer 300 familles et 150 seniors des communes prioritaires à au moins 3 ateliers d'éducation alimentaire et améliorer de 20 % la part des participants qui déclarent cuisiner des légumes au moins 4 fois par semaine. »
3. Processus : nombre d'ateliers réalisés (cible : 40 sur 4 ans). Résultat : part des participants qui déclarent cuisiner des légumes au moins 4 fois par semaine (cible : + 20 %). Satisfaction : part des participants satisfaits ou très satisfaits (cible : 80 %).

Corrigé – Exercice 6.5

1. International : recommandation de l'OMS d'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. National, stratégie : SNANC 2025-2030 (accès de tous à une alimentation plus saine) (la SNS 2023-2033 n'est encore qu'un projet). National, programme : PNNS 5 (2026-2030), actions sur les « 1000 premiers jours » et l'allaitement ; programme « 1000 premiers jours » lancé en 2020. Régional : PRS de l'ARS et son PRAPS. Local : missions de PMI du conseil départemental ; contrat local de santé si la commune en a un.
2. Exemple : « Ce projet s'inscrit dans le programme des 1000 premiers jours et dans le PNNS 5 (2026-2030), qui fait des enfants et de la réduction des inégalités sociales en nutrition une priorité, ainsi que dans le PRAPS du projet régional de santé, qui vise l'accès à la prévention des personnes en situation de

précarité. »

3. Sources officielles et datées : site du ministère chargé de la santé, mangerbouger.fr, site de l'ARS, Légifrance. Vérifier que le texte est en vigueur à la date de l'épreuve, citer son titre exact et sa date, éviter les synthèses non officielles pour les chiffres.

Corrigé – Exercice 6.6

1. Part repérée = 63 / 420 × 100 = 15,0 %. Limite : perte de poids rapportée par les proches, sans pesée ni critère validé ; il faut un repérage selon les critères de la HAS (2021) et une orientation vers le médecin traitant pour le diagnostic.

2. Formation : 2 × 650 = 1 300 € ; ateliers : 12 × 180 = 2 160 € ; balances : 15 × 40 = 600 € ; livret : 420 × 1,50 = 630 € ; coordination : 60 × 35 = 2 100 €. Total = 1 300 + 2 160 + 600 + 630 + 2 100 = 6 790 €. Parts : formation 19,1 % ; ateliers 31,8 % ; balances 8,8 % ; livret 9,3 % ; coordination 30,9 % (la somme fait 99,9 % à cause des arrondis).

3. PNNS 5 : prévention de la dénutrition des personnes âgées parmi ses mesures ; PRS : axe de prévention de la perte d'autonomie ; HAS et FFN (2021) : diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus.

4. Objectif général : prévenir la dénutrition des personnes de 75 ans et plus accompagnées par l'association. Objectifs spécifiques : d'ici 12 mois, 100 % des aides à domicile savent repérer les signes d'alerte de la dénutrition et orienter ; d'ici 12 mois, 80 % des personnes repérées ont été orientées vers leur médecin traitant et ont participé à au moins un atelier.

5. Information et consentement de la personne (et de l'aidant), pesée seulement avec accord et dans le respect de la dignité, données de poids conservées de façon confidentielle et sécurisée et transmises uniquement au médecin avec accord, messages valorisant le plaisir de manger et non culpabilisants, respect des habitudes et des choix.

Partie 7 – Les politiques nutritionnelles de santé publique

Objectifs – Objectifs de la partie

- Retracer l'histoire des politiques nutritionnelles, du PNNS 1 (2001) au PNNS 5 (2026-2030).
- Présenter la SNANC 2025-2030, le PNNS 5 et le PNA 4, et leurs liens.
- Calculer les taux EGalim d'une restauration collective ; utiliser les repères alimentaires de Santé publique France.
- Présenter le Nutri-Score et ses limites ; argumenter une diversification des protéines.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- PNNS 1 (2001-2005), PNNS 2 (2006-2010), PNNS 3 (2011-2015, prolongé jusqu'en 2018), PNNS 4 (2019-2023), PNNS 5 (2026-2030, lancé le 8 avril 2026 : 3 axes, 20 mesures).
- SNANC 2025-2030 : article 265 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 ; publiée le 11 février 2026 ; elle oriente le PNNS (ministère chargé de la santé) et le PNA (ministère chargé de l'agriculture).
- Loi EGalim (30 octobre 2018) : au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de bio, en valeur d'achat hors taxes ; menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire.
- Nutri-Score : logo facultatif de A à E, adopté par l'arrêté du 31 octobre 2017 ; nouvel algorithme rendu applicable par l'arrêté du 14 mars 2025.
- Repères adultes (Santé publique France, 2019) : augmenter (fruits et légumes, légumes secs, fruits à coque, activité physique), aller vers (féculents complets, huiles de colza, de noix, d'olive, poisson, 2 produits laitiers par jour, produits de saison), réduire (alcool, boissons sucrées, produits gras, sucrés, salés et ultra-transformés, charcuterie 150 g par semaine, viande hors volaille 500 g par semaine, sel).

Exercice 7.1 – Légender la frise des politiques nutritionnelles (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

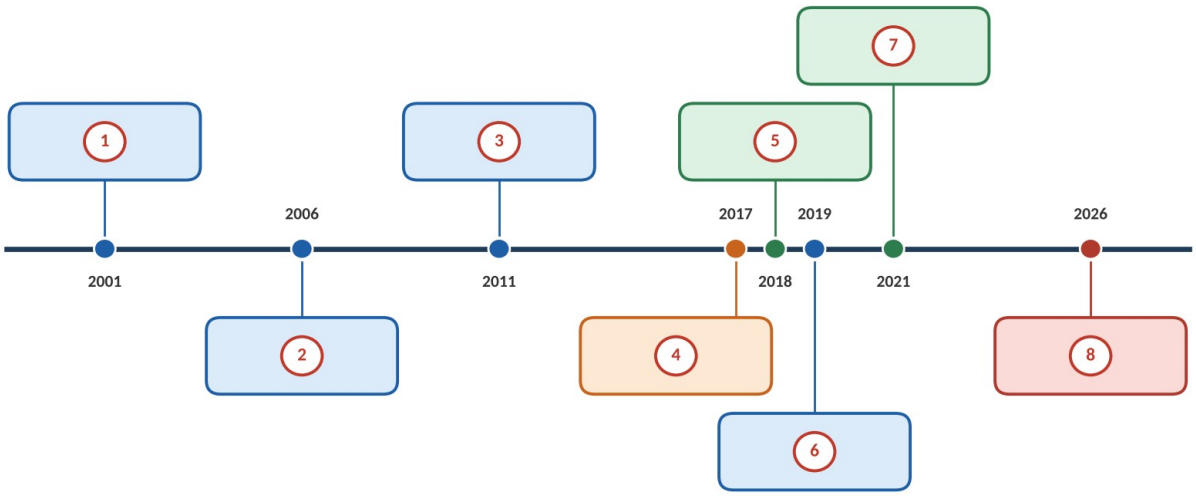


Figure 7.1 – Document 1 – Les grandes étapes des politiques nutritionnelles en France (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les cases 1 à 8 de la frise : nom du programme ou du texte et sa date ou sa période. (8 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.2 – Présenter le PNNS 5 et la SNANC (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

En réunion d'équipe, une animatrice vous demande : « Le PNNS, la SNANC, le PNA, c'est la même chose ? Lequel il faut citer ? »

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez le lien entre la SNANC, le PNNS 5 et le PNA 4 (texte de référence, ministère pilote, période). (4 pts)
2. Citez les trois axes du PNNS 5. (3 pts)
3. Citez trois objectifs chiffrés annoncés pour le PNNS 5. (3 pts)
4. Indiquez la précaution à prendre avant de citer un chiffre du PNNS 5 dans votre dossier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.3 – Calculer les taux EGalim d'une cantine (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au service de restauration scolaire d'une commune (données fictives). La commune doit télédéclarer ses achats de l'année sur la plateforme « ma cantine ».

Document 1 – Achats de denrées de l'année (hors taxes)

Catégorie d'achats	Montant
Total des achats de denrées	184 000 €
dont produits issus de l'agriculture biologique	31 280 €
dont produits sous signe de qualité (Label Rouge, AOP, IGP), non bio	29 440 €
dont produits de la pêche avec écolabel, non bio	11 040 €

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de produits bio et le taux de produits durables et de qualité (le bio en fait partie). (4 pts)
2. Comparez aux obligations de la loi EGalim et calculez, à budget constant, le montant d'achats à faire basculer pour atteindre chaque seuil. (4 pts)
3. Proposez deux leviers pour atteindre les objectifs sans augmenter le prix du repas. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.4 – Utiliser les repères alimentaires (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un stand de prévention dans une entreprise, un salarié de 45 ans décrit sa semaine habituelle.

Document 1 – Semaine habituelle déclarée

Charcuterie : 300 g par semaine. Viande hors volaille : 700 g par semaine. Légumes secs : jamais. Fruits et légumes : 3 portions par jour. Boissons sucrées : 2 verres par jour. Pain : uniquement blanc. Poisson : une fois par mois. Huile : tournesol uniquement. Produits laitiers : 2 par jour.

À vous de jouer – Questions

1. Comparez chaque élément aux repères de Santé publique France ; calculez les dépassements de charcuterie et de viande. (6 pts)
2. Proposez trois changements prioritaires, formulés de façon positive et réaliste. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi ce conseil individuel, donné sur un stand, ne suffit pas et ce que l'entreprise peut faire de plus. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.5 – Le Nutri-Score (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un atelier en supermarché, une participante vous dit : « Les céréales de mon fils sont notées A, donc elles ne sont pas transformées et il peut en manger autant qu'il veut. »

Document 1 – Objectifs annoncés du PNNS 5 sur le Nutri-Score

Part des Français utilisant le Nutri-Score : de 33 % à 40 %. Part du volume des produits transformés affichant le Nutri-Score : de 62 % à 75 %.

À vous de jouer – Questions

1. Présentez le Nutri-Score : ce qu'il mesure, son caractère obligatoire ou non, les textes français, les changements du nouvel algorithme. (4 pts)
2. Relevez les deux erreurs de la participante et corrigez-les. (3 pts)
3. Calculez la hausse en points et en pourcentage pour chacun des deux objectifs du document 1. (3 pts)
4. Proposez une activité d'atelier pour apprendre à utiliser le Nutri-Score. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.6 – Argumenter une diversification des protéines (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une cuisine centrale (structure fictive) sert 450 repas par jour dans les écoles d'une commune, 36 semaines par an. Elle sert déjà un menu végétarien par semaine. Le comité du projet alimentaire territorial propose un deuxième repas végétarien hebdomadaire, à base de légumineuses, et de réinvestir l'économie réalisée dans des produits bio locaux.

Document 1 – Données de coût (prix construits pour le sujet)

Plat carné remplacé : 70 g de viande crue par enfant, à 12,00 € le kg. Plat de légumineuses : 60 g de lentilles sèches par enfant, à 3,60 € le kg. On néglige les autres ingrédients, identiques dans les deux plats.

À vous de jouer – Questions

1. Rappelez les obligations de la loi EGalim et de la loi Climat et résilience sur les menus végétariens et la diversification des protéines en restauration scolaire. (3 pts)
2. Calculez le coût de la portion de viande et de la portion de lentilles, l'économie par repas, puis l'économie annuelle. (5 pts)
3. Présentez les arguments « Une seule santé » et SNANC du projet. (4 pts)
4. Indiquez les conditions de réussite nutritionnelles et d'acceptabilité qui relèvent du diététicien. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 7.1

1 PNNS 1 (2001-2005) ; 2 PNNS 2 (2006-2010) ; 3 PNNS 3 (2011-2015, prolongé) ; 4 Nutri-Score (arrêté du 31 octobre 2017) ; 5 Loi EGalim (30 octobre 2018) ; 6 PNNS 4 (2019-2023) ; 7 Loi Climat et résilience (22 août 2021) ; 8 SNANC (11 février 2026) et PNNS 5 (2026-2030).

Corrigé – Exercice 7.2

1. La SNANC 2025-2030, prévue par l'article 265 de la loi Climat et résilience et publiée le 11 février 2026, fixe les orientations de la politique de l'alimentation durable et de la nutrition. Elle est déclinée par deux programmes 2026-2030 : le PNNS 5, piloté par le ministère chargé de la santé (DGS), et le PNA 4, piloté par le ministère chargé de l'agriculture. Dans un dossier, on cite la SNANC comme cadre et le PNNS 5 (et le PNA 4 si l'action concerne l'offre ou la restauration) comme programme.
2. Axes : « garantir à tous l'accès à des environnements nutritionnels durables favorables à la santé » ; « encourager des comportements nutritionnels sains et durables » ; « faire des milieux de vie des espaces promoteurs de santé ».
3. Objectifs annoncés : réduire de 30 % la prévalence du surpoids et de l'obésité des enfants et adolescents (20 % chez ceux de familles défavorisées) ; 85 % d'enfants allaités à la naissance ; 40 % des Français utilisant le Nutri-Score ; 75 % du volume des produits transformés affichant le Nutri-Score ; 12 % de consommation de produits bio.
4. Vérifier chaque chiffre dans le texte intégral officiel (site du ministère chargé de la santé, mangerbouger.fr) et non dans une synthèse secondaire ; citer la date.

Corrigé – Exercice 7.3

1. Taux de bio = 31 280 / 184 000 × 100 = 17,0 %. Produits durables et de qualité = 31 280 + 29 440 + 11 040 = 71 760 € ; taux = 71 760 / 184 000 × 100 = 39,0 %.
2. Bio : objectif d'au moins 20 %, non atteint ; montant à atteindre = 0,20 × 184 000 = 36 800 € ; il manque 36 800 − 31 280 = 5 520 €. Durables et de qualité : objectif d'au moins 50 %, non atteint ; montant à atteindre = 0,50 × 184 000 = 92 000 € ; il manque 92 000 − 71 760 = 20 240 €.
3. Leviers : diversification des protéines (plats de légumineuses moins chers) ; réduction du gaspillage (grammages adaptés, pesée des restes) ; achat de produits bio de saison ; marchés publics allotis pour permettre aux producteurs locaux de répondre ; travail avec le projet alimentaire territorial.

Corrigé – Exercice 7.4

1. Charcuterie : 300 g pour un repère de 150 g au plus, dépassement de 300 − 150 = 150 g (le double). Viande hors volaille : 700 g pour 500 g au plus, dépassement de 700 − 500 = 200 g. Légumes secs : jamais, pour au moins 2 fois par semaine. Fruits et légumes : 3 portions pour au moins 5. Boissons sucrées : 2 verres pour au plus 1 verre par jour. Pain blanc seulement : aller vers des féculents complets au moins une fois par jour. Poisson : une fois par mois pour 2 fois par semaine, dont 1 poisson gras. Huile de tournesol : aller vers les huiles de colza, de noix et d'olive. Produits laitiers : 2 par jour, conforme.
2. Exemples : « Remplacer 2 repas de viande par semaine par un plat de lentilles ou de pois chiches » ; « Ajouter un fruit au petit-déjeuner et des crudités au déjeuner » ; « Garder une boisson sucrée pour le week-end et boire de l'eau aromatisée en semaine ».
3. Le conseil individuel touche une personne et dépend de sa volonté ; ses effets sont limités si l'environnement ne change pas. L'entreprise peut améliorer l'offre de sa restauration (plats de légumineuses, poisson, pain complet, fruits), modifier les distributeurs, mettre des fontaines à eau, aménager les pauses : c'est créer un milieu favorable.

Corrigé – Exercice 7.5

1. Le Nutri-Score classe les aliments de A (meilleure qualité nutritionnelle) à E selon leur composition pour 100 g (éléments à limiter : énergie, sucres, acides gras saturés, sel ; éléments à favoriser : fibres, protéines, fruits, légumes, légumineuses). Il est facultatif (le droit européen ne permet pas de l'imposer). Il a été adopté par l'arrêté du 31 octobre 2017 ; le nouvel algorithme est rendu applicable par l'arrêté du 14 mars 2025, avec 2 ans de transition : meilleur classement des huiles riches en acides gras insaturés, des poissons gras et des céréales complètes, classement plus sévère des produits salés, sucrés et des boissons édulcorées.

2. Erreur 1 : le Nutri-Score ne mesure pas le degré de transformation (c'est la classification NOVA qui le fait) ; un produit noté A peut être ultra-transformé. Erreur 2 : il compare des produits d'une même catégorie et ne dit rien de la quantité à consommer ; un aliment A ne se mange pas « autant qu'on veut ».

3. Utilisation : 40 − 33 = 7 points ; 7 / 33 × 100 = 21,2 % de hausse. Affichage : 75 − 62 = 13 points ; 13 / 62 × 100 = 21,0 % de hausse.

4. Exemple : jeu de classement de 6 paquets de céréales du petit-déjeuner par Nutri-Score, puis comparaison des listes d'ingrédients et des prix au kilo, et choix d'un petit-déjeuner complet.

Corrigé – Exercice 7.6

1. Loi EGalim (2018) : menu végétarien au moins une fois par semaine en restauration scolaire, pérennisé par la loi Climat et résilience (2021) ; plan pluriannuel de diversification des protéines obligatoire au-delà de 200 couverts par jour (la cuisine centrale, avec 450 repas, est concernée).

2. Portion de viande : 0,070 × 12,00 = 0,84 €. Portion de lentilles : 0,060 × 3,60 = 0,216 €, soit 0,22 €. Économie par repas = 0,84 − 0,216 = 0,624 €, soit 0,62 €. Nombre de repas concernés par an : 450 × 36 = 16 200. Économie annuelle = 16 200 × 0,624 = 10 108,80 €.

3. Une seule santé : santé humaine (plus de fibres, apport de protéines végétales, moins d'acides gras saturés) ; santé des écosystèmes (moins d'émissions de gaz à effet de serre, légumineuses qui enrichissent le sol en azote) ; santé animale (moindre pression sur l'élevage intensif). SNANC : réduire l'impact de l'alimentation sur le climat, permettre l'accès à une alimentation plus saine, soutenir les agriculteurs (économie réinvestie dans le bio local).

4. Nutrition : équivalence protéique (associer légumineuses et céréales, compléter par un produit laitier ou un œuf), apport en fer (vitamine C dans le repas), grammages adaptés à l'âge. Acceptabilité : recettes testées avec les enfants, introduction progressive, présentation attractive, formation des cuisiniers aux cuissons des légumineuses, communication aux familles, suivi des restes pour mesurer l'acceptation.

Partie 8 – Le diététicien-nutritionniste en santé publique et la démarche de projet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer le cadre réglementaire de la profession (article L. 4371-1 du code de la santé publique) et ses missions en santé publique.
- Adopter une posture professionnelle éthique : non-stigmatisation, secret professionnel, RGPD, conflits d'intérêts.
- Décrire les étapes de la démarche de projet et rédiger des objectifs mesurables.
- Mobiliser toutes les notions du chapitre dans un cas complet.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Article L. 4371-1 du CSP : le diététicien dispense des conseils nutritionnels, participe sur prescription médicale à l'éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients, contribue à la qualité de l'alimentation en collectivité et aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.
- Le titre de diététicien est protégé (enregistrement au RPPS) ; le terme « nutritionniste » ne l'est pas.
- Démarche de projet : analyse et diagnostic, priorités et objectifs, plan d'action et moyens, communication, mise en œuvre, évaluation, valorisation et ajustements ; au centre : éthique, déontologie et participation.
- Besoins selon Bradshaw : normatif (défini par l'expert), ressenti (perçu par la personne), exprimé (ressenti devenu demande), comparatif (comparaison avec un groupe semblable).

Exercice 8.1 – Légender la démarche de projet (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

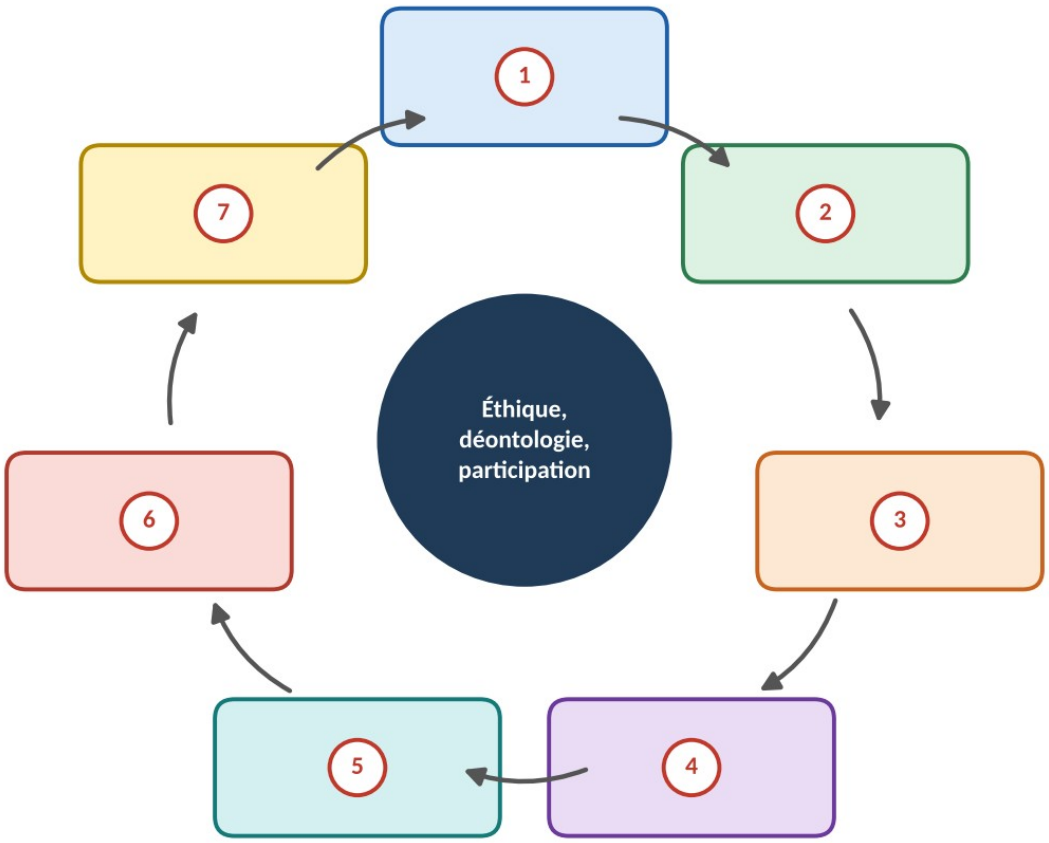


Figure 8.1 – Document 1 – La démarche de projet en santé publique (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les étapes 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)
2. Associez à chaque étape un outil ou un document que vous produisez pendant le stage. (3,5 pts)
3. Expliquez pourquoi la démarche est représentée comme un cycle et ce que contient le disque central. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.2 – Le cadre réglementaire de la profession (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un élu vous demande pourquoi la commune devrait recruter une diététicienne plutôt qu'un « coach en nutrition » pour son projet de santé publique.

À vous de jouer – Questions

1. Citez les quatre champs d'exercice du diététicien définis par l'article L. 4371-1 du CSP. (4 pts)

2. Expliquez la différence entre « diététicien » et « nutritionniste » et le rôle du RPPS. (3 pts)

3. Citez trois employeurs possibles d'un diététicien en santé publique et une mission pour chacun. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.3 – Posture et déontologie en situation (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Document 1 – Six situations de stage

a) À la fin d'un atelier, une participante vous demande de lui écrire un régime pour son diabète.

b) Votre tutrice veut publier sur le site de la structure les photos de l'atelier, où l'on voit les visages des enfants.

c) Une marque de compotes propose de financer les ingrédients des ateliers en échange de son logo sur les affiches.

d) Une animatrice dit devant le groupe : « Avec ton poids, tu devrais éviter le fromage. »

e) Vous recevez par courriel la liste des familles inscrites avec leurs revenus et leurs problèmes de santé.

f) Un participant ne mange pas de porc et n'ose pas le dire.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque situation, identifiez le principe éthique ou réglementaire en jeu et indiquez la conduite à tenir. (12 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.4 – Rédiger des objectifs mesurables (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – méthode · durée conseillée : 20 min*

Document 1 – Objectifs proposés par un stagiaire

a) « Faire prendre conscience aux familles de l'importance de bien manger. »

b) « Améliorer la santé des enfants. »

c) « Organiser des ateliers. »

d) « Que les gens mangent plus de légumes. »

e) « Diminuer l'obésité dans le quartier de 50 % en 3 mois. »

À vous de jouer – Questions

1. Rappelez ce que signifie un objectif SMART. (2 pts)
2. Pour chaque objectif, indiquez son défaut et réécrivez-le de façon mesurable, en précisant s'il s'agit d'un objectif général, spécifique ou opérationnel. (10 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.5 – Classer les besoins selon Bradshaw (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous menez le diagnostic d'un projet dans une épicerie sociale (structure fictive). Vous avez noté les informations ci-dessous.

Document 1 – Informations recueillies

a) 12 bénéficiaires ont demandé à la responsable des recettes avec les produits de l'épicerie. b) Selon les repères de Santé publique France, il faut consommer des légumes secs au moins 2 fois par semaine ; seuls 3 bénéficiaires interrogés sur 20 le font. c) Plusieurs bénéficiaires disent se sentir fatigués et « mal manger », sans rien demander. d) L'épicerie sociale de la commune voisine propose des ateliers cuisine depuis 3 ans ; celle-ci n'en propose pas. e) Une bénévole pense que « les gens ne savent pas cuisiner ».

À vous de jouer – Questions

1. Définissez les quatre types de besoins de Bradshaw. (4 pts)
2. Classez les informations a à d. (4 pts)
3. Indiquez comment traiter l'information e dans le diagnostic. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.6 – Cas de synthèse : la santé alimentaire des étudiants d'un campus (30 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 1 h 30*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage au service de santé étudiante d'une université (structure fictive) qui accueille 14 000 étudiants sur un campus en périphérie d'une ville moyenne. Le restaurant universitaire du CROUS est ouvert le midi en semaine. La direction du service vous confie un projet sur l'alimentation des étudiants, à mener avec l'association étudiante et le CROUS.

Document 1 – Enquête en ligne du service de santé étudiante (données fictives, mars 2026, 640 répondants)

Item	Nombre de « oui »
A sauté au moins un repas par manque d'argent au cours du dernier mois	243
Mange moins de 3 portions de fruits et légumes par jour	371
N'a pas de cuisine équipée dans son logement	154
Souhaite des ateliers « cuisine étudiante »	422

Document 2 – Moyens disponibles

Budget de 3 000 € sur l'année universitaire ; salle avec cuisine pédagogique à la maison des étudiants (8 postes) ; épicerie solidaire étudiante gérée par l'association ; réseaux sociaux de l'université et de l'association ; un diététicien du service à mi-temps.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les indicateurs de l'enquête et commentez la représentativité (taux de réponse, mode de recueil). (4 pts)
2. Qualifiez l'action (mode d'intervention, niveau de prévention, type selon Gordon) et classez les besoins selon Bradshaw. (4 pts)
3. Identifiez les déterminants en jeu en vous appuyant sur le modèle biopsychosocial. (3 pts)
4. Citez les acteurs et partenaires à mobiliser, du national au local, et la politique dans laquelle s'inscrit le projet. (4 pts)
5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et trois objectifs opérationnels. (4 pts)
6. Proposez un plan d'action avec un budget détaillé qui respecte les 3 000 €. (4 pts)
7. Construisez l'évaluation et le plan de communication (précarité numérique, réseaux sociaux, e-réputation). (4 pts)
8. Indiquez trois points de vigilance éthique. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 8.1

1. Légendes : 1 Analyse et diagnostic de situation ; 2 Priorités et objectifs ; 3 Plan d'action et moyens ; 4 Plan de communication ; 5 Mise en œuvre ; 6 Évaluation ; 7 Valorisation et ajustements.
2. Exemples : diagnostic (fiche de diagnostic, arbre à problèmes) ; objectifs (arbre à objectifs, objectifs SMART) ; plan d'action (fiche projet, diagramme de Gantt, budget) ; communication (plan de communication, affiches) ; mise en œuvre (conducteur de séance, fiche technique, grille de dégustation) ; évaluation (questionnaire, tableau de bord) ; valorisation (bilan, tableau de veille, auto-évaluation).
3. L'évaluation produit des résultats qui alimentent un nouveau diagnostic et l'amélioration du projet : c'est un cycle. Au centre, l'éthique, la déontologie et la participation des personnes concernées s'appliquent à toutes les étapes.

Corrigé – Exercice 8.2

1. Dispenser des conseils nutritionnels ; participer, sur prescription médicale, à l'éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients (bilan diététique, éducation diététique) ; contribuer à la qualité de l'alimentation servie en collectivité ; participer aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.
2. Le titre de diététicien est protégé : il est réservé aux titulaires des diplômes reconnus (BTS Diététique et nutrition, BUT Génie biologique parcours diététique et nutrition, ou autorisation d'exercice), enregistrés au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS), ce qui permet de vérifier leur qualification. « Nutritionniste » n'est pas un titre protégé : n'importe qui peut l'utiliser. C'est une garantie de compétence et de respect des règles professionnelles pour la commune.
3. Exemples : commune ou CCAS (coordination du volet nutrition d'un contrat local de santé) ; conseil départemental (ateliers des 1000 premiers jours en PMI) ; mutuelle ou entreprise (programme de prévention pour les salariés).

Corrigé – Exercice 8.3

a) Limite de compétence et cadre de l'atelier : on ne prescrit pas de régime en atelier collectif ; on oriente vers le médecin traitant et une consultation diététique. b) Droit à l'image et RGPD : autorisation écrite des parents, possibilité de refuser, à défaut photos sans visage. c) Conflit d'intérêts : refuser la présence de la marque sur les supports ; chercher des financements publics ou des dons sans contrepartie publicitaire. d) Non-stigmatisation et respect : reprendre l'animatrice en privé, rappeler qu'on ne commente jamais le poids d'une personne en public. e) Confidentialité et minimisation des données : ces données sont excessives pour un atelier ; ne pas les diffuser, demander à les supprimer, conserver seulement ce qui est nécessaire. f) Respect des cultures et des choix : prévoir des alternatives dans les recettes et demander les habitudes alimentaires de façon discrète à l'inscription.

Corrigé – Exercice 8.4

1. SMART : spécifique, mesurable, atteignable (ambitieux mais réaliste), réaliste (pertinent au regard des moyens), temporellement défini.
2. a) Vague, non mesurable. Objectif spécifique : « D'ici 6 mois, 70 % des familles ayant participé à au moins 3 ateliers citent deux repères du PNNS et une recette qu'elles ont refaite. » b) Trop large : c'est un objectif général, à préciser : « Contribuer à améliorer l'alimentation des enfants de 3 à 6 ans des familles du centre social. » c) C'est une activité, pas un objectif : objectif opérationnel : « Animer 6 ateliers de 2 heures pour 10 familles entre janvier et juin. » d) Non mesurable, sans public ni échéance : « D'ici fin juin, faire passer de 25 % à 40 % la part des familles participantes qui servent des légumes au moins une fois par jour. » e) Irréaliste (durée trop courte, ampleur excessive, un projet local ne mesure pas la prévalence

d'un quartier) : reformuler sur des comportements à court terme et laisser la prévalence à un objectif général de long terme.

Corrigé – Exercice 8.5

1. Normatif : défini par un expert à partir d'une norme. Ressenti : perçu par la personne, pas forcément exprimé. Exprimé : besoin ressenti transformé en demande. Comparatif : déduit de la comparaison avec un groupe semblable qui bénéficie d'un service.

2. a) Exprimé. b) Normatif (3 / 20 × 100 = 15,0 % suivent le repère). c) Ressenti. d) Comparatif.

3. C'est une représentation d'un professionnel ou d'un bénévole, pas un besoin du public : elle doit être vérifiée auprès des bénéficiaires (entretiens, questionnaire) et ne doit pas orienter seule le projet, au risque d'un jugement stigmatisant.

Corrigé – Exercice 8.6

1. Indicateurs (nombre / 640 × 100) : repas sautés par manque d'argent 243 / 640 = 38,0 % ; moins de 3 portions de fruits et légumes 371 / 640 = 58,0 % ; pas de cuisine équipée 154 / 640 = 24,1 % ; souhait d'ateliers 422 / 640 = 65,9 %. Taux de réponse = 640 / 14 000 × 100 = 4,6 % : très faible ; enquête en ligne avec réponses volontaires, donc les étudiants intéressés par le sujet ont pu répondre davantage et ceux sans connexion fiable moins. Les résultats sont une première indication, pas une mesure représentative.

2. Promotion de la santé (accès, milieux de vie) et éducation pour la santé (compétences culinaires) ; prévention primaire ; type sélectif pour les étudiants en précarité, universel pour l'offre ouverte à tous (universalisme proportionné). Besoins : normatif (moins de 3 portions de fruits et légumes pour un repère d'au moins 5) ; exprimé (65,9 % demandent des ateliers) ; ressenti (faim, fatigue, stress) ; comparatif (offre d'autres campus, données nationales de précarité étudiante).

3. Biologique : jeunes adultes, besoins énergétiques élevés. Psychologique : stress des examens, isolement, perte des repères familiaux. Social : budget limité, logement sans cuisine (24,1 %), campus en périphérie, horaires des cours, offre du restaurant universitaire limitée au midi en semaine.

4. National : ministère chargé de l'enseignement supérieur, CROUS (restauration et action sociale), PNNS 5 (axe 3 : « faire des milieux de vie des espaces promoteurs de santé », dont l'enseignement supérieur) et SNANC. Régional : ARS (prévention, appels à projets). Local : université et service de santé étudiante, association étudiante et épicerie solidaire, CROUS local, commune, banques alimentaires. Le projet s'inscrit dans l'axe 3 du PNNS 5, qui mobilise les établissements d'enseignement supérieur comme promoteurs de santé.

5. Objectif général : contribuer à améliorer l'alimentation et à réduire l'insécurité alimentaire des étudiants du campus. Objectifs spécifiques : d'ici juin, 70 % des étudiants ayant suivi au moins 2 ateliers savent préparer 3 repas complets à moins de 2 € ; d'ici juin, 90 % des étudiants qui déclarent sauter des repas faute d'argent et qui consultent le service sont orientés vers l'épicerie solidaire ou une aide du CROUS. Objectifs opérationnels : animer 8 ateliers « cuisine étudiante » de 10 places ; organiser 2 marchés de produits frais à prix solidaire ; former 4 étudiants relais à l'orientation vers les aides.

6. Budget : 8 ateliers × 120 € = 960 € ; 2 marchés × 300 € (paniers de produits frais subventionnés) = 600 € ; communication 350 € ; formation des étudiants relais 2 × 400 € = 800 € ; évaluation 150 € ; total = 960 + 600 + 350 + 800 + 150 = 2 860 €, soit une réserve de 3 000 − 2 860 = 140 €.

7. Évaluation : processus (nombre d'ateliers et de participants, paniers distribués) ; résultats (compétences déclarées avant-après, orientations réalisées, repas sautés déclarés dans une nouvelle enquête) ; satisfaction. Communication : réseaux sociaux de l'association (canal principal des étudiants), affiches au restaurant universitaire et à la bibliothèque, relais des étudiants formés, information orale en amphithéâtre ; prise en compte de la précarité numérique (forfaits limités, absence d'ordinateur) par des supports papier et des inscriptions sur place ; e-réputation : pas de photo d'étudiant identifiable associée à la précarité, accord écrit, modération des commentaires.

8. Non-stigmatisation des étudiants en précarité (ateliers ouverts à tous) ; confidentialité des informations

sociales et de santé (RGPD, accès limité au service) ; absence de lien commercial avec des marques ; participation des étudiants à la conception du projet.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Définir la santé (OMS, Ottawa, Huber) et distinguer les modèles de santé	1.1 à 1.6			
2	Définir la santé publique, ses missions ; calculer le paradoxe de Rose, une prévalence, une incidence	2.1 à 2.6			
3	Distinguer danger, exposition, risque, facteurs de risque et de protection ; calculer un risque ; hiérarchiser des problèmes	3.1 à 3.6			
4	Qualifier une action (mode, OMS, Gordon) ; utiliser la Charte d'Ottawa ; appliquer l'universalisme proportionné	4.1 à 4.6			
5	Situer les acteurs ; trouver une source de données ; construire un plan de financement ; repérer un conflit d'intérêts	5.1 à 5.6			
6	Expliquer SNS, PRS, CLS ; relier une action locale aux politiques ; répondre à un appel à projets	6.1 à 6.6			
7	Présenter PNNS 5, SNANC, PNA 4 ; calculer des taux EGalim ; utiliser les repères et le Nutri-Score	7.1 à 7.6			
8	Adopter une posture éthique ; rédiger des objectifs SMART ; classer les besoins ; traiter un cas complet	8.1 à 8.6			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5

CHAPITRE

01

La santé publique et la promotion de la santé en nutrition

Santé publique | Promotion de la santé | Politiques nutritionnelles

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 1 206
Mode d'emploi du cahier d'annales 206
Ce que le jury attend sur ce chapitre 206
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 207
S1 – « Manger, c'est aussi s'insérer » : les jeunes d'une mission locale 207
S2 – « Prendre soin de soi quand on prend soin d'un proche » : un atelier pour les aidants 210
S3 – Soignants de nuit d'un centre hospitalier : du projet à l'atelier 213
Partie II – Les corrigés détaillés 215
Corrigé S1 – « Manger, c'est aussi s'insérer » : les jeunes d'une mission locale 215
Corrigé S2 – « Prendre soin de soi quand on prend soin d'un proche » : un atelier pour les aidants 221
Corrigé S3 – Soignants de nuit d'un centre hospitalier : du projet à l'atelier 226
Grille d'auto-évaluation 230

Cahier d'annales E5 – chapitre 1

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent donc la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes et les données des territoires sont fictives : elles sont construites pour l'entraînement et ne doivent pas être citées comme des données réelles. Les données nationales, elles, sont réelles et datées.

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Manger, c'est aussi s'insérer » : les jeunes d'une mission locale	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Prendre soin de soi quand on prend soin d'un proche » : un atelier pour les aidants	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	Soignants de nuit d'un centre hospitalier : du projet à l'atelier	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 1 donne le cadre de toute l'épreuve : définir la santé et la santé publique, distinguer prévention, promotion et éducation pour la santé, situer son action dans les politiques en vigueur (PNNS 5 2026-2030, SNANC, projet régional de santé, contrat local de santé) et nommer les acteurs. Le jury vérifie que le candidat qualifie correctement son action (mode d'intervention, niveau de prévention, approche populationnelle ou individuelle), qu'il part d'un diagnostic chiffré et sourcé, qu'il formule des objectifs hiérarchisés et mesurables, et qu'il évalue ce qu'il fait. Il vérifie aussi l'éthique : non-stigmatisation, consentement, confidentialité, sécurité des données.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; surligner les chiffres, le public, les contraintes (budget, durée, matériel, nombre de participants) et le verbe de chaque consigne. Pendant : une idée par paragraphe ; chaque objectif avec un indicateur, une valeur cible et une échéance ; chaque calcul posé (formule, application numérique, résultat avec unité). Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Manger, c'est aussi s'insérer » : les jeunes d'une mission locale

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II).

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage de santé publique de 2e année, pendant six semaines, à la Mission locale du Val d'Arvel (structure fictive), qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire vers l'emploi, la formation, le logement et la santé. Votre tutrice est la conseillère référente santé de la structure. Le directeur vous confie une demande : « Beaucoup de jeunes arrivent le ventre vide aux ateliers du matin, certains font des malaises, d'autres nous disent qu'ils sautent des repas pour payer leur forfait téléphone. On voudrait faire quelque chose sur l'alimentation, mais sans faire la morale. » Vous devez concevoir le projet, en réaliser une partie pendant votre stage, et en rendre compte dans votre dossier E5.

Document 1 – La structure et ses moyens

La mission locale suit 1 350 jeunes par an sur une communauté de communes semi-rurale de 41 000 habitants (deux bourgs et 23 villages). Elle accueille chaque matin un groupe de 10 à 14 jeunes en « contrat d'engagement jeune » (CEJ, dispositif national en vigueur depuis le 1er mars 2022, 15 à 20 heures d'activités par semaine, allocation versée sous conditions de ressources). Locaux : une salle de réunion, un espace détente avec réfrigérateur, bouilloire et four à micro-ondes, aucun équipement de cuisson. À 300 m, le centre social dispose d'une cuisine pédagogique (2 plaques à induction, 1 four, 8 postes de travail) prêtable le mercredi après-midi. Budget accordé par la communauté de communes au titre du contrat local de santé : 1 800 € pour six mois, matériel compris. Personnes ressources : conseillère référente santé, deux conseillers emploi, animatrice du centre social, bénévoles de l'épicerie sociale. Minibus de 9 places disponible le mardi.

Document 2 – Portrait du territoire (données fictives construites pour le sujet)

Indicateur	Communauté de communes	Département	Source fictive, année
Part des 15-24 ans ni en emploi, ni en études, ni en formation	17 %	13 %	Observatoire régional, 2024
Taux de pauvreté des moins de 30 ans	24 %	19 %	Observatoire régional, 2023
Supermarchés à moins de 10 min à pied d'un arrêt de bus	2	–	Diagnostic du CLS, 2025
Fréquence des bus vers le bourg principal	4 allers-retours par jour	–	Diagnostic du CLS, 2025
Jeunes de 16-25 ans sans permis de conduire parmi les jeunes suivis	58 %	–	Mission locale, 2025

Le contrat local de santé (CLS) 2024-2028 de la communauté de communes, signé avec l'agence régionale de santé, comprend un axe « Alimentation, précarité et santé des jeunes ».

Document 3 – Enquête flash réalisée par la mission locale (données fictives)

Questionnaire anonyme sur papier, rempli en salle d'attente pendant deux semaines de mars 2026 par 212 jeunes, sur les 1 350 suivis.

Question (sur les 7 derniers jours ou le dernier mois)	Nombre de « oui » (n = 212)
A sauté le petit-déjeuner au moins 4 jours sur 7	97
A mangé des fruits ou des légumes chaque jour	53
A bu une boisson sucrée ou énergisante chaque jour	89
A renoncé à au moins un repas faute d'argent au cours du dernier mois	74
N'a pas de quoi cuisiner chez lui (pas de plaque ni de four)	38
Souhaite apprendre à cuisiner « vite et pas cher »	121

Document 4 – Extraits du groupe de parole organisé par la conseillère (6 jeunes)

« Le matin je prends un energy drink, ça coupe la faim et ça réveille. » (Kenza, 19 ans)

« Je vis chez ma tante, je n'ose pas me servir dans le frigo. » (Théo, 18 ans)

« Les légumes c'est cher et ça pourrit avant que je les mange. » (Yanis, 22 ans)

« Je sais faire des pâtes, c'est tout. Ma mère ne m'a jamais montré. » (Lina, 17 ans)

« Les flyers sur manger-bouger, on les jette. Mais une vidéo de 30 secondes sur Insta, je regarde. » (Malik, 21 ans)

« Moi je veux bien venir cuisiner si on mange ce qu'on fait et si on peut l'emporter. » (Inès, 24 ans)

Document 5 – Ce que propose l'équipe de la mission locale

Un conseiller propose : « On pourrait peser les jeunes au début et à la fin pour voir si ça marche, et créer un groupe WhatsApp où ils envoient les photos de leurs assiettes. On mettra les photos sur la page Facebook de la mission locale pour valoriser le projet. »

Document 6 – Cadre des politiques publiques (données réelles)

Le programme national nutrition santé 2026-2030 (PNNS 5) a été lancé le 8 avril 2026 ; il compte 3 axes et 20 mesures. La stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat (SNANC), prévue par l'article 265 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, a été publiée le 11 février 2026. Les projets alimentaires territoriaux (PAT) visent à relocaliser l'alimentation sur un territoire ; 450 PAT étaient reconnus au 1er juillet 2025. Le contrat local de santé est prévu par l'article L. 1434-10 du code de la santé publique : il décline localement le projet régional de santé.

Travail à faire

Partie A – Le projet d'intervention (dossier écrit de 10 pages au plus) – C3.1 (9 points)

1. Qualifiez l'action demandée : mode d'intervention, niveau de prévention, type d'approche, place dans les politiques publiques du document 6. (1 pt)
2. À partir des documents 2 à 4, calculez les indicateurs de l'enquête flash en pourcentage ; calculez le taux de participation ; posez le diagnostic de situation en distinguant les besoins exprimés, ressentis, normatifs et comparatifs (Bradshaw) ; construisez l'arbre à problèmes. (2 pts)
3. Formulez l'objectif général, deux ou trois objectifs spécifiques et les objectifs opérationnels, chacun avec un indicateur, une valeur cible et une échéance. Justifiez vos priorités. (1,5 pt)

4. Présentez le plan d'action sur six mois (actions, public, partenaires, calendrier) et un budget détaillé qui respecte les 1 800 €. (1,5 pt)

5. Présentez le plan de communication en tenant compte de la précarité numérique et de la littératie en santé du public. (1 pt)

6. Construisez la démarche d'évaluation (processus, résultats, impact) avec les outils de recueil. (1 pt)

7. Proposez les modalités de valorisation du projet et les ajustements possibles. (1 pt)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée – C3.3 (3 points)

8. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion de jeunes ayant renoncé à un repas faute d'argent, puis le nombre de jeunes à interroger pour obtenir une précision de ± 5 points. (1,5 pt)

9. Identifiez les biais de l'enquête flash et proposez un protocole d'enquête de suivi (population, échantillonnage, outil, recueil, traitement, éthique). (1,5 pt)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

10. Organisez une veille sur l'alimentation des jeunes en situation de précarité : besoins, sources fiables, outils, fréquence, diffusion à l'équipe. (2 pts)

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique – C3.5 et C3.6 (3 points)

11. Analysez la proposition du document 5 sur les plans éthique, juridique et de la sécurité numérique ; proposez une alternative. (1,5 pt)

12. Rédigez la trame minutée de votre exposé de 10 minutes et listez 15 questions probables du jury. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Prendre soin de soi quand on prend soin d'un proche » : un atelier pour les aidants

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des sujets U62 et E5.B (bon de commande, fiche technique, organisation dans le temps, hygiène) et du BTS blanc CNED E5B (enrichissement et calcul nutritionnel), adaptée au format du temps 2 de l'E5 du référentiel 2024.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

La plateforme d'accompagnement et de répit des aidants de la ville de Bressac (structure fictive) accompagne des personnes qui s'occupent chaque jour d'un proche atteint de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. L'équipe a constaté que beaucoup d'aidants « mangent sur le pouce », sautent des repas, perdent du poids et se sentent épuisés. Elle vous demande de concevoir et d'animer un atelier culinaire de 2 heures, dans le cadre du programme « Prendre soin de soi », avec un double objectif : montrer qu'on peut préparer en 30 minutes un plat complet, bon et peu coûteux, qui convient à la fois à l'aidant et au proche ; et montrer comment adapter ce plat lorsque le proche a des troubles de la mastication.

Document 1 – Le public et les contraintes

- 8 aidants de 52 à 81 ans (6 femmes, 2 hommes) ; 2 aidants ont un diabète de type 2 traité par metformine ; 1 aidant a une hypertension artérielle ; 1 aidante de 81 ans a perdu 4 kg en 6 mois (poids actuel 52 kg).
- 3 proches ont des difficultés de mastication et mangent des textures hachées ; un proche est allergique à l'arachide (il ne participe pas à l'atelier mais l'aidante veut pouvoir refaire la recette chez elle).
- Les aidants disposent chez eux d'une cuisine standard ; plusieurs disent « ne plus avoir envie de cuisiner pour deux ».
- Atelier : salle d'animation avec cuisine pédagogique (4 plaques à induction, 1 four mixte, 1 mixeur plongeant, 1 robot coupe, 1 réfrigérateur, 1 lave-vaisselle), 4 postes de travail de 2 personnes.
- Budget denrées : 30 € pour l'atelier, soit 10 portions (8 aidants et 2 animateurs).
- Durée de l'atelier avec le public : 2 heures, de 14 h 00 à 16 h 00. Le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 2 – Recette imposée de base (pour 10 portions) et dessert

Plat : gratin de pâtes complètes, brocolis et poulet, sauce blanche enrichie.

Dessert : coupe de fromage blanc, compote pomme-poire minute et biscuit sec émietté.

Le candidat doit réaliser le plat ; le dessert peut être réalisé par les participants. Il doit aussi présenter une version du plat en texture hachée, adaptée au proche qui a des troubles de la mastication (niveau IDDSI 5 « haché et humide »).

Document 3 – Grammages bruts, coefficients et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Grammage net par portion	Coefficient de perte (brut → net)	Prix (2026)
Pâtes alimentaires complètes, sèches	60 g	sans perte	1,90 € le kg

Denrée	Grammage net par portion	Coefficient de perte (brut → net)	Prix (2026)
Brocoli frais	120 g	35 % de perte	2,80 € le kg
Filet de poulet cru	70 g	sans perte	11,50 € le kg
Lait demi-écrémé	100 mL	sans perte	1,05 € le litre
Lait en poudre écrémé	8 g	sans perte	12,00 € le kg
Farine de blé	8 g	sans perte	1,10 € le kg
Huile de colza	6 g	sans perte	3,20 € le litre (1 L = 920 g)
Emmental râpé	15 g	sans perte	9,80 € le kg
Fromage blanc nature 3 % de matière grasse	100 g	sans perte	2,60 € le kg
Pommes	60 g	20 % de perte	2,40 € le kg
Poires	60 g	20 % de perte	3,20 € le kg
Biscuit sec type petit-beurre	8 g	sans perte	4,50 € le kg
Sel, poivre, muscade, citron	–	–	forfait 0,60 € pour l'atelier

Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte).

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Pâtes sèches, au blé complet, cuites, sans sel ajouté	179	7,35	31,3	1,4	5,1	0,055
Brocoli, cuit (aliment moyen)	30	3,17	1,79	0,6	2,59	0,036
Poulet, filet sans peau grillé/poêlé	141	30,1	0	2	0	0,14
Lait demi-écrémé, UHT	47,7	3,48	5	1,56	0	0,088
Lait en poudre, écrémé	361	35,3	54	0,7	0	1,32
Farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains)	350	9,03	73,7	1	3,2	< 0,13
Huile de colza	900	0	0	100	0	< 0,0028
Emmental ou emmenthal, râpé	368	27,6	0,58	28,2	0,042	0,68
Fromage blanc, nature, 2-3% MG	75,7	7,28	3,86	3,23	0,019	0,088
Pomme, chair sans peau, crue (aliment moyen)	51,3	0,26	11,9	0,24	2,39	0,0064
Poire, chair, crue (aliment moyen)	49,7	0,25	11,4	< 0,5	3,1	< 0,013
Biscuit sec petit beurre	450	7,78	73,4	13,3	2,54	1,04

Rendements de cuisson donnés pour le sujet : 60 g de pâtes sèches complètes donnent 120 g de pâtes cuites ; 70 g de filet de poulet cru donnent 56 g de poulet poêlé ; on compte 120 g de brocoli cuit par portion. On admet que 100 mL de lait pèsent 100 g. Les valeurs ne comprennent pas le sel ajouté à la cuisson. Une teneur notée « < » (inférieure au seuil de mesure) ou « traces » est comptée 0 dans les calculs.

Source : ANSES, table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2025 (fichier du 3 novembre 2025,

mis en ligne le 19 novembre 2025) ; énergie calculée selon le règlement (UE) n° 1169/2011 ; protéines N × facteur de Jones.

Document 5 – Repères pour le public

- Repères du PNNS pour les adultes (Santé publique France, 2019 ; mangerbouger.fr) : féculents complets au moins une fois par jour, au moins 5 fruits et légumes par jour, 2 produits laitiers par jour, réduire le sel.
- Personnes âgées à risque de dénutrition : HAS et FFN, recommandations de 2021 sur le diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus ; apport protéique conseillé autour de 1,0 à 1,2 g par kg de poids et par jour chez la personne âgée.
- IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative) : niveau 5 « haché et humide » = morceaux de 4 mm au plus chez l'adulte, humides, sans liquide qui se sépare, qui s'écrasent facilement à la fourchette.

Travail à faire

Partie 1 – Conception de l'atelier (8 points)

1. Identifiez les besoins, les objectifs et les spécificités du public ; formulez l'objectif général et trois objectifs pédagogiques de l'atelier. (2 pts)
2. Établissez le bon de commande en deux exemplaires pour 10 portions : quantités nettes, quantités brutes, unités d'achat, coût total et coût par portion ; vérifiez le respect du budget. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique du plat (ingrédients, techniques, étapes, points critiques, températures) et la fiche de la version hachée. (2 pts)
4. Calculez, avec la table Ciqual, l'apport en énergie, protéines, glucides, lipides, fibres et sel d'une portion du plat ; comparez l'apport protéique au besoin de l'aidante de 81 ans ; proposez deux techniques d'enrichissement supplémentaires. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (6 points)

5. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (mise en place, accueil, animation, dégustation, évaluation, remise en état), avec la répartition des tâches entre les binômes. (2 pts)
6. Choisissez les méthodes d'animation et les outils pédagogiques ; préparez la grille de dégustation. (2 pts)
7. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité (méthode des 5 M, températures, allergènes, conservation des restes) et les gestes éco-responsables. (2 pts)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (6 points)

8. Réalisez le gratin et sa version hachée ; dressez deux assiettes témoins. (4 pts : techniques maîtrisées, qualité organoleptique, texture conforme, hygiène pendant la production)
9. Proposez la démarche d'évaluation de l'atelier (satisfaction, acquis, intention de refaire la recette) et l'auto-évaluation de votre animation. (2 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Soignants de nuit d'un centre hospitalier : du projet à l'atelier

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet mixte – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) sur une même situation

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : 30 min d'oral préparé (temps 1) et 3 h (temps 2) · Barème : 20 points par temps.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique au service de santé au travail du centre hospitalier de Valmont (structure fictive), 1 900 agents, dont 310 travaillent de nuit en postes de 10 heures (de 21 h 00 à 7 h 00). Le médecin du travail constate chez ces agents des plaintes de fatigue, de troubles digestifs et une prise de poids. Le restaurant du personnel est fermé la nuit : seuls deux distributeurs automatiques sont accessibles. La direction des ressources humaines souhaite une action « Bien manger quand on travaille de nuit », inscrite dans la démarche de qualité de vie et des conditions de travail de l'établissement.

Document 1 – Données nationales (données réelles)

- En 2012, 15,4 % des salariés travaillaient la nuit, de façon habituelle ou occasionnelle (DARES, Analyses, 2014).
- L'ANSES (avis et rapport de juin 2016 sur le travail de nuit) conclut à des effets avérés sur la somnolence et la qualité du sommeil, et à des effets probables sur le syndrome métabolique, les troubles psychiques, les maladies cardiovasculaires et certains cancers.

Document 2 – Enquête du service de santé au travail (données fictives)

Questionnaire en ligne envoyé aux 310 agents de nuit ; 124 réponses.

Item	Nombre de réponses « oui »
Ne prend pas de vrai repas pendant la nuit	68
Achète au moins une fois par nuit au distributeur (barres, sodas, chips)	81
Boit plus de 4 cafés ou boissons caféinées par nuit	43
Déclare une prise de poids depuis le passage de nuit	57
Souhaite des idées de repas à préparer à l'avance	96

Document 3 – Moyens disponibles

Salle de pause de chaque service : réfrigérateur, four à micro-ondes, bouilloire. Cuisine du restaurant du personnel prêtée un après-midi par mois pour un atelier de 10 personnes (2 plaques à induction, 1 four mixte, 1 cellule de refroidissement rapide, 5 postes de travail). Budget annuel : 2 500 €. Le prestataire des distributeurs accepte de modifier 30 % de l'offre.

Travail à faire – Temps 1

1. Calculez les indicateurs de l'enquête et le taux de réponse ; posez le diagnostic et ses limites. (4 pts)
2. Formulez les objectifs (général, spécifiques, opérationnels) et le plan d'action sur 12 mois, avec une action sur l'environnement (distributeurs) et une action éducative. (5 pts)
3. Présentez le plan de communication, en tenant compte des horaires décalés, et la démarche d'évaluation. (4 pts)

4. Proposez une revue de la littérature sur l'alimentation et le travail de nuit : équation de recherche, bases de données, critères de sélection. (3 pts)
5. Indiquez les précautions éthiques et de sécurité numérique d'un questionnaire en ligne de santé au travail. (2 pts)
6. Expression et sources. (2 pts)

Travail à faire – Temps 2

Contexte imposé : atelier de 1 h 30 pour 10 agents de nuit, dans la cuisine du restaurant du personnel. Thème : « Ma boîte de nuit » : préparer à l'avance un repas de nuit facile à réchauffer ou à manger froid, et un en-cas de fin de nuit. Contraintes : coût des denrées au plus 3,50 € par participant ; repas transportable au réfrigérateur dans une boîte réutilisable ; pas de friture.

Préparations imposées : salade-repas en bocal (lentilles, carottes, œuf, vinaigrette à l'huile de colza) et houmous maison de pois chiches avec bâtonnets de légumes.

Document 4 – Données pour le temps 2 (prix construits pour le sujet ; composition : table Ciqual 2025, ANSES, 19 novembre 2025)

Salade-repas, grammages nets par portion : lentilles vertes sèches 60 g (150 g cuites, rendement de cuisson donné) ; carottes 80 g (15 % de perte à l'épluchage) ; 1 œuf (50 g sans coquille) ; huile de colza 10 g ; vinaigre de cidre, moutarde, persil, échalote (forfait 1,00 € pour 10 portions).

Prix : lentilles vertes 3,60 € le kg ; carottes 1,40 € le kg ; œufs 0,30 € pièce ; huile de colza 3,20 € le litre (1 L = 920 g).

Aliment (libellé Ciqual 2025), pour 100 g	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)
Lentille verte, bouillie/cuite à l'eau	125	10,1	16,2	0,58	8,45
Carotte, crue	30,2	0,78	5,16	< 0,5	2,9
Oeuf dur	134	13,5	0,52	8,62	0
Huile de colza	900	0	0	100	0

Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0 dans les calculs.

7. Identifiez les besoins et les objectifs de l'atelier ; justifiez le choix des préparations au regard du travail de nuit. (3 pts)
8. Établissez le bon de commande et la fiche technique de la salade-repas pour 10 portions ; calculez son apport en énergie, protéines et fibres avec la table Ciqual. (5 pts)
9. Présentez le déroulé de l'atelier, les techniques d'animation et la grille de dégustation. (4 pts)
10. Présentez les règles d'hygiène pour un repas préparé à l'avance et transporté (refroidissement, conservation à 4 °C au plus, durée de conservation, réchauffage) et les éco-gestes. (4 pts)
11. Réalisez les deux préparations et évaluez l'atelier. (4 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Manger, c'est aussi s'insérer » : les jeunes d'une mission locale

que le jury attend

Le jury ne cherche pas un projet parfait : il évalue une démarche. Il attend un diagnostic chiffré et sourcé, des objectifs cohérents avec ce diagnostic, des actions réalistes avec les moyens réellement disponibles (1 800 €, une cuisine prêtée le mercredi, un minibus le mardi), une évaluation prévue dès la conception et un regard critique sur ce qui a été fait. Il pénalise la morale (« il faut manger cinq fruits et légumes »), la stigmatisation (pesée), les objectifs sans indicateur et le manque de sources.

Partie A – Le projet d'intervention

Question 1 – Qualifier l'action (1 pt)

- Mode d'intervention : promotion de la santé (charte d'Ottawa, 1986), qui associe une action sur les compétences des jeunes (éducation pour la santé : savoir cuisiner simple et pas cher, lire une étiquette) et une action sur l'environnement (petit-déjeuner disponible à la mission locale, accès à l'épicerie sociale, transport le mardi). On parle de promotion et non seulement d'éducation, car le problème principal est d'abord un problème de ressources et d'accès.
- Niveau de prévention : prévention primaire (classification de l'OMS), car on agit avant l'apparition de pathologies ; en classification de Gordon, prévention sélective, car on vise un groupe exposé à un risque plus élevé (jeunes en précarité).
- Approche : approche de population ciblée, participative (les jeunes sont associés dès le diagnostic), avec une logique d'universalisme proportionné : l'offre est ouverte à tous les jeunes suivis mais renforcée pour les plus fragiles.
- Place dans les politiques : déclinaison locale du PNNS 5 (2026-2030) et de la SNANC (février 2026) ; inscription dans l'axe « Alimentation, précarité et santé des jeunes » du contrat local de santé (article L. 1434-10 du code de la santé publique), lui-même décliné du projet régional de santé de l'ARS ; lien possible avec le projet alimentaire territorial s'il en existe un.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Confondre prévention et promotion de la santé ; parler de « prévention secondaire » alors qu'aucun dépistage n'est fait ; citer le PNNS 4 (2019-2023) comme programme en cours ; oublier que le CLS est l'outil de déclinaison locale.

Question 2 – Diagnostic de situation (2 pts)

Calcul posé – Indicateurs de l'enquête flash

Pourcentage = nombre de « oui » / effectif × 100.

- Petit-déjeuner sauté au moins 4 jours sur 7 : 97 / 212 × 100 = 45,8 %.
- Fruits ou légumes chaque jour : 53 / 212 × 100 = 25,0 %.
- Boisson sucrée ou énergisante chaque jour : 89 / 212 × 100 = 42,0 %.
- Renoncement à un repas faute d'argent dans le mois : 74 / 212 × 100 = 34,9 %.
- Pas d'équipement de cuisson : 38 / 212 × 100 = 17,9 %.
- Souhait d'apprendre à cuisiner : 121 / 212 × 100 = 57,1 %.

Taux de participation = 212 / 1 350 × 100 = 15,7 %.

Analyse. Plus d'un jeune sur trois renonce à des repas pour raisons financières : c'est une situation d'insécurité alimentaire. Près d'un jeune sur deux saute le petit-déjeuner, ce qui est cohérent avec les malaises signalés le matin. Un jeune sur quatre seulement mange des fruits ou des légumes chaque jour. Quatre jeunes sur dix boivent chaque jour une boisson sucrée ou énergisante (caféine, sucre), souvent pour « couper la faim » (document 4). Près d'un jeune sur cinq ne peut pas cuisiner chez lui. Le territoire cumule les difficultés : plus de jeunes sans emploi ni formation et plus de pauvreté chez les moins de 30 ans que dans le département, peu de commerces accessibles en bus, 58 % des jeunes suivis sans permis.

Les besoins selon Bradshaw :

Type de besoin	Définition	Dans la situation
Normatif	Défini par des experts à partir d'une norme	Repères du PNNS : au moins 5 fruits et légumes par jour, limiter les boissons sucrées ; 25,0 % seulement en mangent chaque jour
Ressenti	Perçu par la personne, pas toujours dit	Faim le matin, fatigue, gêne à se servir chez un proche (Théo)
Exprimé	Ressenti transformé en demande	57,1 % veulent apprendre à cuisiner « vite et pas cher » ; Inès veut emporter ce qu'elle cuisine
Comparatif	Écart avec un groupe semblable qui bénéficie d'un service	Taux de pauvreté des moins de 30 ans de 24 % contre 19 % dans le département ; peu d'accès aux commerces

Arbre à problèmes. Problème central : une alimentation insuffisante et déséquilibrée chez les jeunes suivis. Causes : ressources faibles et arbitrages budgétaires (forfait téléphone) ; absence d'équipement de cuisson ; manque de compétences culinaires ; isolement géographique et transport rare ; logement chez un tiers ; marketing des boissons énergisantes. Effets : malaises et baisse de la concentration en atelier, absentéisme, fatigue, risque de prise de poids ou de carences, perte d'estime de soi, freins à l'insertion.

Limites – Limites à citer

Taux de participation de 15,7 % ; questionnaire en salle d'attente (les jeunes les plus en difficulté viennent peut-être moins) ; données déclaratives ; groupe de parole de 6 jeunes non représentatif. Le diagnostic est donc une première estimation qui doit être complétée (partie B).

Question 3 – Priorités et objectifs (1,5 pt)

Priorités retenues : le petit-déjeuner (lien direct avec les malaises, action rapide et visible), les compétences culinaires à petit budget (demande exprimée par 57,1 % des jeunes) et l'accès aux ressources alimentaires (insécurité alimentaire de 34,9 %). Les boissons énergisantes sont traitées dans les ateliers, sans action séparée.

- Objectif général : contribuer à améliorer l'alimentation des jeunes suivis par la mission locale du Val d'Arvel, en renforçant leurs compétences et en améliorant leur accès à une alimentation suffisante et équilibrée, d'ici 6 mois.
- Objectif spécifique 1 : d'ici 6 mois, réduire de 45,8 % à 30 % la part des jeunes en CEJ qui sautent le petit-déjeuner au moins 4 jours sur 7.
- Objectif spécifique 2 : d'ici 6 mois, 70 % des jeunes ayant suivi au moins 3 ateliers déclarent savoir préparer seuls au moins 2 repas complets pour moins de 2 € par portion.
- Objectif spécifique 3 : d'ici 6 mois, 80 % des jeunes ayant déclaré renoncer à des repas ont été orientés vers une aide alimentaire adaptée (épicerie sociale, CCAS).
- Objectifs opérationnels : mettre en place un petit-déjeuner partagé deux matins par semaine dès le mois 1 ; animer 6 ateliers culinaires de 2 h le mercredi au centre social, de 8 jeunes chacun ; organiser 4 sorties en minibus à l'épicerie sociale et au marché ; produire 6 vidéos de 30 secondes de recettes avec les jeunes ; former les conseillers au repérage de l'insécurité alimentaire (1 séance de 1 h 30).

Chaque objectif a un indicateur, une valeur cible et une échéance : c'est ce qui le rend évaluable.

Question 4 – Plan d'action et budget (1,5 pt)

Mois	Action	Partenaires
1	Comité de pilotage ; présentation aux jeunes ; formation des conseillers au repérage	Direction, conseillère santé, coordinatrice du CLS
1 à 6	Petit-déjeuner partagé le mardi et le jeudi (12 jeunes)	Épicerie sociale (dons), jeunes volontaires
2 à 5	6 ateliers culinaires « vite et pas cher » le mercredi, 8 jeunes, recettes sans four pour les jeunes non équipés	Centre social, diététicien
2 à 5	4 sorties en minibus le mardi : épicerie sociale, marché, lecture des prix au kilo	Bénévoles, épicerie sociale
3 à 6	Tournage de 6 vidéos de 30 secondes par les jeunes	Animatrice numérique du centre social
6	Évaluation, restitution, valorisation	Toute l'équipe, élus du CLS

Calcul posé – Budget prévisionnel (prix construits pour le sujet)

- Petit-déjeuner : 2 matins × 24 semaines = 48 petits-déjeuners × 12 jeunes = 576 petits-déjeuners × 0,90 € = 518,40 €.
- Ateliers : 6 ateliers × 10 personnes (8 jeunes et 2 animateurs) × 2,00 € = 120 € ; boîtes réutilisables pour emporter : 48 boîtes × 2,50 € = 120 €.
- Petit matériel pour les ateliers et le petit-déjeuner (bouilloire, mixeur plongeant, plaque à induction mobile, ustensiles) : 420 €.
- Impressions (affiches, livret de recettes de 12 pages en 60 exemplaires) : 180 €.
- Carburant du minibus : 4 sorties × 25 € = 100 €.
- Récompenses symboliques et goûter de restitution : 150 €.

Total = 518,40 + 120 + 120 + 420 + 180 + 100 + 150 = 1 608,40 €, soit une marge de 1 800 − 1 608,40 = 191,60 € pour les imprévus.

Question 5 – Plan de communication (1 pt)

- Cibles : les jeunes (bénéficiaires), les conseillers (relais), les partenaires et les élus (financeurs).
- Messages : positifs, sans culpabilisation (« Cuisiner pour 2 € », « Un petit-déjeuner pour bien commencer l'atelier »), centrés sur le goût, le budget et l'autonomie.
- Supports adaptés à la littératie en santé : affiches très visuelles avec pictogrammes, recettes en 5 étapes illustrées, vidéos courtes tournées par les jeunes, message oral des conseillers lors des entretiens. Une vidéo de 30 secondes correspond aux usages (document 4).
- Précarité numérique : forfaits limités, téléphones partagés, peu d'ordinateurs ; on ne compte donc pas que sur le numérique. Les vidéos sont diffusées en salle d'attente sur un écran, les recettes existent aussi sur papier, le QR code renvoie à une page légère.
- Calendrier : lancement au mois 1, rappel avant chaque atelier, restitution au mois 6.

Question 6 – Démarche d'évaluation (1 pt)

Niveau	Indicateurs	Outils
Processus	Nombre d'ateliers réalisés sur 6 prévus ; nombre de participants par atelier ; nombre de petits-déjeuners servis ; budget consommé ; respect du calendrier	Feuilles d'émargement, tableau de suivi, factures
Résultats	Part des jeunes qui sautent le petit-déjeuner (comparaison avec 45,8 %) ; part des jeunes qui savent préparer 2 repas à moins de 2 € ; nombre de jeunes orientés vers l'aide alimentaire	Même questionnaire qu'au départ (avant-après), fiche de compétences remplie en fin d'atelier, registre des orientations

Niveau	Indicateurs	Outils
Satisfaction	Appréciation des ateliers et des recettes	Questionnaire à smileys, mur d'expression
Impact (à plus long terme)	Malaises signalés en atelier ; assiduité aux activités du CEJ	Registre de la mission locale, sur un an

L'évaluation est prévue dès le début, avec les mêmes questions avant et après pour pouvoir comparer.

Question 7 – Valorisation et ajustements (1 pt)

Valorisation : restitution aux élus et aux partenaires du CLS ; livret de recettes réalisé par les jeunes ; diffusion des vidéos avec l'accord écrit des jeunes ; article dans le bulletin de la communauté de communes ; présentation au réseau régional des missions locales ; reprise possible dans le PAT.

Ajustements : si les jeunes ne viennent pas le mercredi, déplacer l'atelier juste après une activité obligatoire du CEJ ; si la cuisine du centre social n'est pas disponible, ateliers sans cuisson (bocaux, salades, tartines) dans l'espace détente ; si le budget du petit-déjeuner est dépassé, solliciter les dons de l'épicerie sociale ou des commerces.

Partie B – Recherche appliquée

Question 8 – Intervalle de confiance et taille d'échantillon (1,5 pt)

Calcul posé – Intervalle de confiance à 95 % d'une proportion

p = 74 / 212 = 0,349 ; n = 212.

Erreur = 1,96 × racine carrée de [p × (1 − p) / n] = 1,96 × racine carrée de (0,349 × 0,651 / 212) = 0,064.

IC à 95 % = [0,349 − 0,064 ; 0,349 + 0,064] = [28,5 % ; 41,3 %].

Interprétation : si l'échantillon était représentatif, la vraie proportion de jeunes suivis ayant renoncé à un repas se situerait entre 28,5 % et 41,3 %, avec un risque d'erreur de 5 %.

Taille d'échantillon pour une précision de ± 5 points : n = 1,96 × 1,96 × p × (1 − p) / (0,05 × 0,05) = 3,8416 × 0,349 × 0,651 / 0,0025 = 349,1 ; on arrondit toujours au nombre entier supérieur : 350 jeunes.

Question 9 – Biais et protocole de suivi (1,5 pt)

Biais : biais de sélection (jeunes présents en salle d'attente pendant deux semaines, 15,7 % de participation, absence probable des plus isolés) ; biais de désirabilité sociale (questionnaire rempli dans les locaux de la structure) ; biais de mémoire (dernier mois) ; questions non validées.

Protocole : population = tous les jeunes suivis en CEJ ; échantillonnage = recueil systématique pendant les entretiens individuels sur une période définie (tous les jeunes reçus), avec un objectif de 350 réponses ; outil = questionnaire court, anonyme, avec des questions issues d'outils validés (par exemple un indicateur d'insécurité alimentaire reconnu) et testé auprès de 5 jeunes ; recueil avant le projet et 6 mois après, sur papier ou sur tablette hors ligne ; traitement = tableur, pourcentages et intervalles de confiance, comparaison avant-après ; éthique = information claire, participation libre, anonymat, pas de donnée nominative ni de donnée de santé identifiante, données conservées sur un poste sécurisé et détruites à la fin de l'étude, conformité au RGPD (minimisation des données).

Partie C – Veille

Question 10 – Organiser la veille (2 pts)

- Besoins : suivre les données sur l'alimentation et la précarité des jeunes, les dispositifs d'aide alimentaire, les recommandations nutritionnelles et les outils d'intervention.
- Sources fiables : Santé publique France et mangerbouger.fr (repères, outils), ministère chargé de la santé (PNNS 5), ministère chargé de l'agriculture (SNANC, PAT, programme national pour l'alimentation), ANSES (études INCA, avis), Drees et Insee (pauvreté), Observatoire régional de la santé, IREPS et Promotion Santé (outils pédagogiques, interventions probantes), Haut Conseil de la santé publique.

- Outils : alertes par mots-clés, abonnements aux lettres d'information, flux RSS, agrégateur, tableau de veille partagé (date, source, résumé en 3 lignes, intérêt pour le projet).
- Fréquence : 30 minutes par semaine, bilan mensuel.
- Diffusion : une fiche de veille d'une page par mois à l'équipe, présentée en réunion ; seule l'information utile au projet est diffusée.
- Évaluation de la veille : nombre d'informations utilisées dans le projet, avis de l'équipe.

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique

Question 11 – Analyse de la proposition du document 5 (1,5 pt)

- Peser les jeunes : la pesée n'est pas un objectif du projet (il ne s'agit pas d'un projet de perte de poids), elle est stigmatisante, elle peut éloigner les jeunes et elle produit une donnée de santé. Elle est donc à refuser.
- Groupe WhatsApp avec photos d'assiettes : messagerie privée hors du système d'information de la structure, numéros de téléphone visibles par tous, jugement possible des assiettes entre pairs, pas de maîtrise de la conservation des données.
- Publication sur Facebook : droit à l'image (accord écrit nécessaire, accord des parents pour les mineurs comme Lina, 17 ans), e-réputation des jeunes (un employeur peut voir qu'ils fréquentent une mission locale ou ont des difficultés alimentaires), données excessives au regard du RGPD.
- Alternative : évaluer par questionnaire anonyme ; partager les recettes et non les assiettes ; outil de messagerie choisi par la structure, avec un compte professionnel ; photos de mains et de plats, sans visage, publiées seulement avec un accord écrit et la possibilité de le retirer ; mots de passe forts et double authentification pour les comptes de la structure.

Question 12 – Trame de l'exposé et questions du jury (1,5 pt)

Préparer l'oral – Trame de l'exposé de 10 minutes

- 0 min 00 à 1 min 00 : présentation de la structure, de la demande et de mon rôle de stagiaire.
- 1 min 00 à 3 min 00 : diagnostic (3 chiffres clés de l'enquête, contexte territorial, besoins selon Bradshaw, limites).
- 3 min 00 à 4 min 00 : priorités et objectifs (un objectif spécifique détaillé avec son indicateur).
- 4 min 00 à 6 min 30 : actions réalisées pendant le stage (par exemple 2 ateliers et 6 petits-déjeuners), outils et partenariats.
- 6 min 30 à 8 min 00 : évaluation (premiers résultats chiffrés) et communication.
- 8 min 00 à 9 min 30 : analyse critique : ce qui a fonctionné, difficultés, ajustements, éthique.
- 9 min 30 à 10 min 00 : conclusion et ce que ce projet m'a appris pour mon métier.

Questions probables du jury – Questions probables et réponses attendues

1. Pourquoi parlez-vous de promotion de la santé et pas seulement d'éducation ? On agit aussi sur l'environnement et l'accès, pas seulement sur les connaissances.
2. Quel est le niveau de prévention ? Primaire (OMS), sélective (Gordon).
3. Votre enquête est-elle représentative ? Non : 15,7 % de participation, recueil en salle d'attente ; il faut un recueil systématique et 350 réponses.
4. Comment avez-vous calculé votre intervalle de confiance ? Formule de la proportion, 1,96 pour 95 %.
5. Pourquoi ne pas avoir pesé les jeunes ? Ce n'est pas un objectif, c'est stigmatisant, c'est une donnée de santé.
6. Quel lien avec le PNNS 5 ? Déclinaison locale par le CLS ; repères alimentaires et lutte contre les inégalités sociales de santé.
7. Qu'est-ce qu'un CLS ? Contrat entre l'ARS et une collectivité pour décliner le projet régional de santé sur un territoire (article L. 1434-10 du CSP).
8. Comment avez-vous pris en compte la précarité numérique ? Supports papier, écran en salle d'attente,

page légère, pas d'application à télécharger.

9. Quels partenaires et pourquoi ? Centre social (cuisine), épicerie sociale (accès, dons), CLS (financement), bénévoles (sorties).
10. Comment avez-vous adapté vos recettes aux jeunes sans équipement ? Recettes sans cuisson ou au four à micro-ondes, petit matériel prêté.
11. Votre objectif spécifique 1 est-il réaliste ? Justifier par la durée, la fréquence du petit-déjeuner et l'évaluation intermédiaire.
12. Quels sont les effets des boissons énergisantes ? Apport de sucre et de caféine, sensation de faim masquée, troubles du sommeil ; l'ANSES (avis de 2013) les déconseille aux enfants et aux adolescents.
13. Comment avez-vous associé les jeunes ? Groupe de parole, choix des recettes, tournage des vidéos.
14. Quels documents réglementaires pour les photos ? Autorisation de droit à l'image, accord parental pour les mineurs, RGPD.
15. Qu'avez-vous fait pour sécuriser les données de l'enquête ? Anonymat, poste avec session personnelle, mot de passe, destruction en fin d'étude.
16. Que changeriez-vous ? Une réponse argumentée, honnête, avec un ajustement concret.
17. Comment le projet peut-il durer après votre stage ? Recettes et vidéos réutilisables, conseillers formés, inscription dans le CLS.

Grille d'évaluation et barème

Partie	Indicateurs du référentiel évalués	Points
A – Projet	Analyse et diagnostic de situation posé ; priorités et objectifs formulés et adaptés au contexte ; plan d'action et moyens réalistes ; plan de communication adapté ; démarche d'évaluation construite ; valorisation ; ajustements envisagés (C3.1)	9
B – Recherche	Méthodes et outils de collecte pertinents ; traitement et analyse des données ; règles de déontologie et d'éthique (C3.3)	3
C – Veille	Besoins identifiés ; technique de veille adaptée ; sources fiables ; diffusion organisée ; pertinence évaluée (C3.4)	2
D – Communication et numérique	Supports adaptés au public ; précarité numérique ; e-réputation ; identité numérique ; environnement numérique sécurisé (C3.5, C3.6)	3
Expression	Expression écrite et orale maîtrisée ; vocabulaire ; sources datées	3
Total		20

Niveaux de maîtrise pour chaque partie : non maîtrisé (moins de 25 % des points), insuffisamment maîtrisé (25 à 49 %), maîtrisé (50 à 79 %), bien maîtrisé (80 % et plus).

Corrigé S2 – « Prendre soin de soi quand on prend soin d'un proche » : un atelier pour les aidants

que le jury attend

Le temps 2 évalue une seule compétence, C3.2, mais avec tous ses indicateurs : besoins du public identifiés, techniques culinaires adaptées, adaptation à une alimentation particulière (ici la texture), documents techniques exacts, animation, organisation, qualité des préparations, dégustation, hygiène, éco-gestes et évaluation. Un plat réussi sans animation ni évaluation ne suffit pas ; une animation brillante avec un plat mal cuit non plus.

Partie 1 – Conception de l'atelier

Question 1 – Besoins, objectifs et spécificités du public (2 pts)

Besoins et spécificités : public adulte et âgé, en situation de charge mentale et physique importante (risque d'épuisement de l'aidant) ; repas sautés et perte d'envie de cuisiner « pour deux » ; risque de dénutrition (aidante de 81 ans qui a perdu 4 kg en 6 mois, soit 4 / 56 × 100 = 7,1 % de son poids initial de 56 kg) ; diabète de type 2 chez 2 aidants (féculents complets et fibres, répartition des glucides) ; hypertension chez 1 aidant (sel limité) ; proches avec troubles de la mastication (texture hachée) ; allergie à l'arachide chez un proche (vérifier les étiquettes, en particulier du biscuit et de l'huile) ; peu de temps disponible.

Définition – Perte de poids et dénutrition (HAS et FFN, 2021)

Chez la personne de 70 ans et plus, une perte de poids d'au moins 5 % en 1 mois ou d'au moins 10 % en 6 mois est un critère phénotypique de dénutrition. La perte de 7,1 % en 6 mois de l'aidante n'atteint pas ce seuil, mais elle justifie une vigilance et une orientation vers son médecin traitant ; l'atelier n'est pas un acte de diagnostic.

- Objectif général : permettre aux aidants de préparer facilement, chez eux, des repas complets, agréables et peu coûteux, adaptés à eux-mêmes et à leur proche.
- Objectif pédagogique 1 : à la fin de l'atelier, chaque participant sait réaliser un plat complet en 30 minutes, avec un féculent complet, un légume et une source de protéines.
- Objectif pédagogique 2 : à la fin de l'atelier, chaque participant sait citer et utiliser deux techniques d'enrichissement simples (lait en poudre, fromage râpé, œuf).
- Objectif pédagogique 3 : à la fin de l'atelier, chaque participant sait adapter la texture du plat pour un proche qui mâche difficilement (hacher, humidifier, vérifier à la fourchette).

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – Quantités brutes et coût des denrées pour 10 portions

Quantité nette pour 10 portions = grammage net × 10. Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte).

- Brocoli : net = 120 × 10 = 1 200 g ; brut = 1 200 / (1 − 0,35) = 1 200 / 0,65 = 1 846 g, soit 1,85 kg ; coût = 1,846 × 2,80 = 5,17 €.
- Pommes : net = 600 g ; brut = 600 / 0,80 = 750 g ; coût = 0,750 × 2,40 = 1,80 €.
- Poires : net = 600 g ; brut = 750 g ; coût = 0,750 × 3,20 = 2,40 €.
- Huile de colza : 60 g = 60 / 920 = 0,065 L ; coût = 0,065 × 3,20 = 0,21 €.
- Autres denrées (sans perte) : pâtes 0,600 kg × 1,90 = 1,14 € ; poulet 0,700 kg × 11,50 = 8,05 € ; lait 1,000 L × 1,05 = 1,05 € ; lait en poudre 0,080 kg × 12,00 = 0,96 € ; farine 0,080 kg × 1,10 = 0,09 € ; emmental 0,150 kg × 9,80 = 1,47 € ; fromage blanc 1,000 kg × 2,60 = 2,60 € ; petit-beurre 0,080 kg × 4,50 = 0,36 €.
- Forfait condiments : 0,60 €.

Total = 25,90 € ; coût par portion = 25,90 / 10 = 2,59 €. Le budget de 30 € est respecté (marge de 4,10 €).

Denrée	Quantité nette	Quantité brute à commander	Unité d'achat	Prix unitaire	Coût
Pâtes complètes sèches	600 g	0,600 kg	kg	1,90 €	1,14 €
Brocoli frais	1 200 g	1,850 kg	kg	2,80 €	5,17 €
Filet de poulet cru	700 g	0,700 kg	kg	11,50 €	8,05 €
Lait demi-écrémé	1 000 mL	1 L	L	1,05 €	1,05 €
Lait en poudre écrémé	80 g	0,080 kg	kg	12,00 €	0,96 €
Farine de blé	80 g	0,080 kg	kg	1,10 €	0,09 €
Huile de colza	60 g	0,065 L	L	3,20 €	0,21 €
Emmental râpé	150 g	0,150 kg	kg	9,80 €	1,47 €
Fromage blanc 3 % MG	1 000 g	1,000 kg	kg	2,60 €	2,60 €
Pommes	600 g	0,750 kg	kg	2,40 €	1,80 €
Poires	600 g	0,750 kg	kg	3,20 €	2,40 €
Petit-beurre	80 g	0,080 kg	kg	4,50 €	0,36 €
Sel, poivre, muscade, citron	–	–	forfait	–	0,60 €
Total					25,90 €

Le bon de commande est établi en deux exemplaires (un pour le fournisseur ou le magasin, un conservé pour le contrôle à réception). En pratique, on arrondit les quantités aux conditionnements du commerce ; le coût affiché ici est le coût matière des quantités utilisées.

Question 3 – Fiche technique du plat et de la version hachée (2 pts)

Modèle à recopier – Fiche technique – Gratin de pâtes complètes, brocolis et poulet, sauce blanche enrichie (10 portions)

Matériel : 2 casseroles de 5 L, 1 sauteuse, 1 casserole à fond épais, fouet, plat à gratin de 30 × 40 cm, thermomètre-sonde, planche et couteau réservés aux viandes crues (code couleur).

1. Mise en place : se laver les mains ; sortir les denrées au dernier moment ; laver les brocolis, détailler en petites fleurettes, éplucher et émincer les tiges.
2. Cuire les pâtes dans une grande quantité d'eau bouillante peu salée (environ 1 L par 100 g), 2 minutes de moins que le temps indiqué ; égoutter.
3. Cuire les brocolis à l'eau bouillante ou à la vapeur 6 à 8 minutes ; ils restent légèrement fermes et bien verts.
4. Détailler le poulet en dés de 1,5 cm sur la planche réservée ; le saisir dans la sauteuse avec un filet d'huile jusqu'à cuisson complète à cœur (chair blanche jusqu'au centre, contrôle au thermomètre-sonde) ; laver la planche et les mains aussitôt.
5. Sauce blanche enrichie : chauffer l'huile, ajouter la farine, cuire le roux 2 minutes sans coloration ; délayer hors du feu le lait froid mélangé au lait en poudre ; porter à ébullition en fouettant ; cuire 2 minutes ; assaisonner (muscade, poivre, peu de sel).
6. Mélanger pâtes, brocolis, poulet et sauce ; verser dans le plat ; parsemer d'emmental.
7. Gratiner au four à 200 °C pendant 10 à 15 minutes.
8. Servir aussitôt ou maintenir à 63 °C au moins jusqu'au service.

Points critiques : volaille crue (contamination croisée, cuisson complète) ; sauce au lait (attacher, grumeaux) ; maintien en température.

Version hachée (IDDSI niveau 5) : prélever 2 portions avant de gratiner ; hacher au robot coupe par impulsions courtes le poulet et les pâtes, écraser les brocolis à la fourchette ; ajouter de la sauce chaude pour obtenir un

mélange humide, sans liquide qui se sépare ; morceaux de 4 mm au plus ; parsemer de fromage qu'on fait fondre sans croûte dure ; test à la fourchette (le mélange s'écrase facilement avec une pression légère, il tient dans la fourchette sans couler). Dresser en deux zones de couleur pour garder l'envie de manger.

Question 4 – Analyse nutritionnelle et enrichissement (2 pts)

Calcul posé – Apport d'une portion de gratin (table Ciqual 2025, document 4)

Apport = quantité (g) × teneur pour 100 g / 100.

Aliment	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Pâtes complètes cuites	120 g	214,8	8,82	37,56	1,68	6,12	0,07
Brocoli cuit	120 g	36,0	3,80	2,15	0,72	3,11	0,04
Poulet poêlé	56 g	79,0	16,86	0	1,12	0	0,08
Lait demi-écrémé	100 g	47,7	3,48	5,00	1,56	0	0,09
Lait en poudre écrémé	8 g	28,9	2,82	4,32	0,06	0	0,11
Farine T55	8 g	28,0	0,72	5,90	0,08	0,26	0
Huile de colza	6 g	54,0	0	0	6,00	0	0
Emmental râpé	15 g	55,2	4,14	0,09	4,23	0,01	0,10
Total d'une portion		544	40,7	55,0	15,5	9,5	0,48

Exemple de ligne : pâtes = 120 × 179 / 100 = 214,8 kcal ; poulet = 56 × 30,1 / 100 = 16,86 g de protéines.

Part de l'énergie apportée par les protéines = 40,7 × 4 / 544 × 100 = 29,9 %.

Interprétation : la portion apporte environ 544 kcal et 40,7 g de protéines ; c'est un plat complet, riche en protéines et en fibres (9,5 g), avec peu de sel apporté par les ingrédients (0,48 g, sans compter le sel de cuisson, qu'on limite pour l'aidant hypertendu). Pour l'aidante de 81 ans (52 kg), le besoin protéique est d'environ 52 × 1,0 = 52 g à 52 × 1,2 = 62,4 g par jour : la portion couvre 40,7 / 62,4 × 100 = 65,2 % à 40,7 / 52 × 100 = 78,3 % de ce besoin. Le dessert ajoute 8,2 g de protéines et 172 kcal (fromage blanc 100 g : 7,28 g ; pomme et poire : 0,31 g ; petit-beurre 8 g : 0,62 g). Les glucides (55,0 g) viennent surtout des pâtes complètes, riches en fibres : c'est adapté aux aidants diabétiques, avec une portion de féculents à garder stable d'un repas à l'autre. Remarque : avec la table Ciqual 2025, les pâtes complètes cuites sont moins hydratées que dans l'édition 2020 (179 kcal pour 100 g au lieu de 127) ; il faut donc toujours citer l'édition de la table utilisée.

Attention – Portion et appétit

Une portion de 544 kcal peut être trop volumineuse pour une personne âgée qui a peu d'appétit : on peut servir une demi-portion enrichie (un jaune d'œuf ou 10 g de fromage en plus) et fractionner avec une collation.

Techniques d'enrichissement supplémentaires : ajouter un œuf battu ou un jaune d'œuf à la sauce hors du feu ; ajouter de la poudre de lait ou du fromage râpé dans une purée ou un potage ; utiliser de la crème fraîche ou un filet d'huile dans les légumes ; proposer un dessert lacté enrichi. On enrichit sans augmenter le volume de l'assiette, car l'appétit est souvent faible.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 5 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire	Candidat	Participants
13 h 00 – 13 h 30	Réception et contrôle des denrées (températures, dates, état) ; rangement ; mise en place des 4 postes ; affichage de la recette	–
13 h 30 – 14 h 00	Pré-cuissons de démonstration prêtes (eau à ébullition) ; préparation de la grille de dégustation	–
14 h 00 – 14 h 15	Accueil, présentation, brise-glace « mon plat de réconfort », rappel du lavage des mains	Lavage des mains, tablier, charlotte
14 h 15 – 14 h 25	Démonstration du roux et de la sauce enrichie	Observation, questions
14 h 25 – 15 h 00	Guidage des binômes	Binôme 1 : pâtes ; binôme 2 : brocolis ; binôme 3 : poulet ; binôme 4 : sauce et dessert
15 h 00 – 15 h 15	Assemblage, gratinage, préparation de la version hachée avec démonstration du test à la fourchette	Assemblage, test de texture
15 h 15 – 15 h 40	Dégustation guidée et échanges : « comment le refaire chez moi pour deux ? », congélation des portions	Dégustation, grille
15 h 40 – 16 h 00	Évaluation, remise de la fiche recette, temps d'échange sur le répit	Questionnaire de fin d'atelier
16 h 00 – 16 h 30	Remise en état, plonge, tri des déchets, gestion des restes, bilan écrit	–

Question 6 – Animation, outils pédagogiques et grille de dégustation (2 pts)

Méthodes : méthode active (les participants font), démonstrative pour les gestes techniques (roux, test IDDSI), interrogative pour partir de leurs habitudes, travail en binômes pour rompre l'isolement. Posture : écoute active, valorisation, aucune remarque sur le poids. Outils : fiche recette illustrée en grands caractères, carte « 3 techniques d'enrichissement », photo des 4 niveaux de texture, astuces « cuisiner une fois, manger deux fois » (portions congelées).

Critère	1 (pas du tout)	2	3	4 (tout à fait)
Aspect et couleurs				
Odeur				
Goût (sel, épices)				
Texture du gratin				
Texture de la version hachée				
Envie de refaire la recette				

Question 7 – Hygiène, sécurité et éco-gestes (2 pts)

Méthode des 5 M : main-d'œuvre (lavage des mains à l'arrivée, après la manipulation du poulet cru, après être allé aux toilettes ; tenue propre, cheveux couverts, pas de bijoux ; personne malade exclue de la manipulation) ; matériel (planches à code couleur, thermomètre-sonde désinfecté, plan de nettoyage) ; matières premières (contrôle à réception, respect de la chaîne du froid, dates limites, étiquettes vérifiées pour l'arachide) ; milieu (marche en avant dans le temps : légumes, puis viande crue, puis nettoyage ; plans de travail désinfectés) ; méthode (cuisson à cœur, maintien à 63 °C au moins, refroidissement rapide des restes de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 heures, conservation entre 0 et 3 °C, conformément à l'arrêté du 21 décembre 2009).

Allergènes : informer sur les 14 allergènes à déclaration obligatoire présents (gluten, lait) ; l'arachide n'est pas dans la recette, mais on vérifie les mentions « peut contenir » du biscuit.

Restes : les participants n'emportent pas de plat chaud resté à température ambiante ; on propose des boîtes remplies et refroidies aussitôt.

Éco-gestes : produits de saison, épluchures de brocoli utilisées (tiges émincées), cuisson couvercle posé, eau de cuisson réutilisée pour la plonge, tri des déchets, boîtes réutilisables, lave-vaisselle plein.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 8 – Critères de réussite de la réalisation (4 pts)

Pâtes fermes et non collantes ; brocolis verts et légèrement croquants ; poulet cuit à cœur et tendre ; sauce lisse, nappante, sans grumeaux ; gratin doré, sans brûlé ; version hachée humide et homogène, conforme au test IDDSI ; deux assiettes témoins dressées proprement, à bonne température ; poste propre pendant toute la production.

Question 9 – Évaluation de l'atelier et auto-évaluation (2 pts)

Évaluation : questionnaire de satisfaction à 4 niveaux ; quiz oral de 3 questions sur les objectifs (citer 2 techniques d'enrichissement, décrire le test à la fourchette, nommer les 3 composantes du plat complet) ; intention de refaire la recette ; appel ou question au début de l'atelier suivant (« l'avez-vous refaite ? »).

Auto-évaluation : respect du minutage, participation de tous les binômes, qualité des préparations, incidents d'hygiène, ajustements à prévoir (par exemple prévoir un poste assis pour un aidant fatigué).

Barème – Barème du temps 2 (C3.2)

Indicateur du référentiel	Points
Besoins, objectifs et spécificités du public identifiés	2
Documents techniques rédigés et contenus argumentés (bon de commande, fiche technique, analyse nutritionnelle)	4
Techniques d'adaptation de l'alimentation standard maîtrisées (texture hachée, enrichissement)	2
Organisation de l'atelier cohérente ; méthodes d'animation et outils pédagogiques appropriés ; techniques de dégustation	4
Pratique des techniques culinaires et qualité organoleptique	4
Règles d'hygiène et de sécurité ; gestes éco-responsables	2
Démarche d'évaluation de l'atelier	2
Total	20

Corrigé S3 – Soignants de nuit d'un centre hospitalier : du projet à l'atelier

que le jury attend

Le sujet mixte vérifie la cohérence : l'atelier du temps 2 doit découler du diagnostic et des objectifs du temps 1. Le jury attend aussi une vraie prise en compte du travail de nuit (horaires décalés pour la communication, conservation au froid des repas préparés à l'avance, caféine, rythme des repas), et non un discours général sur l'équilibre alimentaire.

Temps 1

Question 1 – Indicateurs, diagnostic et limites (4 pts)

Calcul posé – Indicateurs de l'enquête (n = 124)

Taux de réponse = 124 / 310 × 100 = 40,0 %.

- Pas de vrai repas la nuit : 68 / 124 × 100 = 54,8 %.
- Au moins un achat au distributeur par nuit : 81 / 124 × 100 = 65,3 %.
- Plus de 4 boissons caféinées par nuit : 43 / 124 × 100 = 34,7 %.
- Prise de poids déclarée depuis le passage de nuit : 57 / 124 × 100 = 46,0 %.
- Souhait d'idées de repas préparés à l'avance : 96 / 124 × 100 = 77,4 %.

IC à 95 % de la proportion « pas de vrai repas » : p = 0,548 ; erreur = 1,96 × racine carrée de (0,548 × 0,452 / 124) = 0,088 ; IC = [46,1 % ; 63,6 %].

Diagnostic : plus d'un agent de nuit sur deux ne prend pas de vrai repas ; deux sur trois achètent au distributeur des produits gras, sucrés ou salés ; un sur trois consomme beaucoup de caféine ; près d'un sur deux déclare une prise de poids. Le besoin exprimé est fort (77,4 % veulent des idées de repas). L'environnement est défavorable : restaurant fermé, offre des distributeurs pauvre. Ces constats sont cohérents avec les effets probables du travail de nuit sur le syndrome métabolique décrits par l'ANSES en 2016.

Limites : taux de réponse de 40,0 % (les agents les plus concernés ont pu répondre davantage) ; données déclaratives ; prise de poids non mesurée ; pas de groupe de comparaison avec les agents de jour.

Question 2 – Objectifs et plan d'action (5 pts)

- Objectif général : contribuer à améliorer l'alimentation et la santé des agents de nuit du centre hospitalier, en agissant sur leurs compétences et sur leur environnement alimentaire, d'ici 12 mois.
- Objectif spécifique 1 (comportement) : d'ici 12 mois, faire passer de 54,8 % à 35 % la part des agents de nuit qui ne prennent pas de vrai repas pendant leur poste.
- Objectif spécifique 2 (environnement) : d'ici 6 mois, 30 % de l'offre des distributeurs est remplacée par des produits de meilleure qualité nutritionnelle (Nutri-Score A ou B, fruits, produits laitiers nature, eau).
- Objectifs opérationnels : 10 ateliers « Ma boîte de nuit » de 10 agents sur l'année (un par mois sauf juillet et août) ; un cahier des charges des distributeurs rédigé avec le prestataire au mois 2 ; une affiche et un livret « repas de nuit » diffusés dans tous les services au mois 3 ; un réfrigérateur et un four à micro-ondes vérifiés dans chaque salle de pause.

Période	Action	Acteurs
Mois 1	Comité de pilotage : médecin du travail, DRH, cadres de nuit, représentants du personnel, diététicien, restauration	Service de santé au travail
Mois 2	Cahier des charges des distributeurs	Restauration, prestataire, acheteur
Mois 2 à 12	Ateliers culinaires mensuels	Diététicien, cuisinier du restaurant du personnel

Période	Action	Acteurs
Mois 3	Livret et affiches ; stand de nuit dans le hall à 23 h et à 4 h	Communication, service de santé au travail
Mois 6 et 12	Évaluation intermédiaire et finale	Comité de pilotage

Budget indicatif sur 2 500 € : denrées des ateliers 10 × 10 agents × 3,50 € = 350 € ; boîtes réutilisables 100 × 4,00 € = 400 € ; livret et affiches 600 € ; petit matériel des salles de pause 700 € ; temps de stand de nuit et goûters de lancement 300 € ; réserve 150 €. Total = 350 + 400 + 600 + 700 + 300 + 150 = 2 500 €.

Question 3 – Communication et évaluation (4 pts)

Communication adaptée aux horaires décalés : relais par les cadres de nuit pendant les transmissions ; affiches dans les salles de pause ; message sur l'intranet et la messagerie professionnelle ; stand tenu la nuit, et non seulement en journée ; inscription aux ateliers possible par téléphone ou formulaire papier ; atelier placé en début d'après-midi un jour de repos, rémunéré comme temps de formation si l'établissement l'accepte.

Évaluation : processus (nombre d'ateliers réalisés, nombre de participants, part de l'offre des distributeurs modifiée, ventes des nouveaux produits fournies par le prestataire) ; résultats (même questionnaire à 6 et 12 mois : part des agents qui prennent un repas, consommation de caféine, achats au distributeur) ; satisfaction (questionnaire en fin d'atelier) ; impact à plus long terme (données de la visite d'information et de prévention, sans transmission de données individuelles hors du service de santé au travail).

Question 4 – Revue de la littérature (3 pts)

- Question : quelles interventions nutritionnelles améliorent l'alimentation et la santé métabolique des travailleurs de nuit ?
- Équation de recherche en anglais : ("night work" OR "shift work" OR "night shift") AND (diet OR nutrition OR "meal timing" OR "eating behavior") AND (intervention OR program) ; en français : « travail de nuit » ET (alimentation OU nutrition).
- Bases : PubMed (MEDLINE), Cochrane Library, Google Scholar pour la littérature grise, sites de l'ANSES, de l'INRS et de Santé publique France.
- Critères d'inclusion : publications de moins de 10 ans, adultes travailleurs de nuit, études d'intervention ou revues systématiques, langues française et anglaise ; exclusion : études animales, travailleurs de jour seuls.
- Lecture : sélection sur titre, puis résumé, puis texte complet ; tableau de synthèse (auteur, année, pays, type d'étude, population, intervention, résultats, niveau de preuve) ; références selon une norme unique (Vancouver ou APA).

Question 5 – Éthique et sécurité numérique (2 pts)

Questionnaire de santé au travail : participation libre, information sur le but et l'usage des réponses, anonymat réel (aucun recoupement possible entre service, âge et sexe dans un petit service), données de santé hébergées sur un outil validé par le délégué à la protection des données de l'établissement et non sur un outil grand public, accès réservé au service de santé au travail, durée de conservation fixée, résultats présentés seulement de façon globale. Côté sécurité : lien envoyé par la messagerie professionnelle, jamais de mot de passe demandé, vigilance contre l'hameçonnage (un faux questionnaire peut imiter l'enquête), poste verrouillé, export des données sur un espace sécurisé.

Temps 2

Question 7 – Besoins, objectifs et choix des préparations (3 pts)

Besoins : un repas de nuit facile, rassasiant sans être lourd, qui se garde au réfrigérateur et se mange froid ou réchauffé en quelques minutes ; un en-cas de fin de nuit qui évite le distributeur ; réduire la caféine dans la seconde moitié du poste pour préserver le sommeil de récupération.

Objectifs de l'atelier : à la fin, chaque participant sait préparer à l'avance une salade-repas complète en moins de 20 minutes, sait la conserver en sécurité, et sait réaliser un en-cas maison.

Choix : la salade de lentilles associe un féculent riche en fibres et en protéines végétales, un légume et un œuf ; elle tient bien au corps, se conserve et coûte peu. Le houmous avec bâtonnets de légumes est un en-cas riche en fibres, qui se garde au froid et remplace les chips du distributeur.

Question 8 – Bon de commande, fiche technique et analyse nutritionnelle (5 pts)

Calcul posé – Bon de commande de la salade-repas (10 portions)

- Lentilles vertes sèches : 60 × 10 = 600 g ; coût = 0,600 × 3,60 = 2,16 €.
- Carottes : net = 80 × 10 = 800 g ; brut = 800 / (1 − 0,15) = 800 / 0,85 = 941 g ; coût = 0,941 × 1,40 = 1,32 €.
- Œufs : 10 œufs × 0,30 = 3,00 €.
- Huile de colza : 10 × 10 = 100 g = 100 / 920 = 0,109 L ; coût = 0,109 × 3,20 = 0,35 €.
- Forfait assaisonnement : 1,00 €.

Total = 2,16 + 1,32 + 3,00 + 0,35 + 1,00 = 7,83 € ; soit 0,78 € par portion. Il reste 3,50 − 0,78 = 2,72 € par participant pour le houmous et les bâtonnets.

Modèle à recopier – Fiche technique – Salade-repas en bocal (10 portions)

1. Trier et rincer les lentilles ; les cuire départ eau froide, sans sel, 20 à 25 minutes à frémissement ; saler en fin de cuisson ; égoutter.
2. Cuire les œufs 10 minutes à l'eau bouillante ; refroidir aussitôt à l'eau froide ; écaler ; couper en quartiers.
3. Laver, éplucher et râper les carottes sur un poste réservé aux légumes.
4. Vinaigrette : moutarde, vinaigre, échalote ciselée, huile de colza, persil.
5. Refroidir les lentilles en cellule de refroidissement rapide (de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 heures).
6. Montage en bocal, du bas vers le haut : vinaigrette, lentilles, carottes, œuf ; fermer ; étiqueter (nom, date de fabrication, date limite).
7. Conserver entre 0 et 4 °C ; consommer dans les 48 heures ; transport en sac isotherme avec pain de glace ; mettre au réfrigérateur du service dès l'arrivée ; mélanger au moment de manger.

Calcul posé – Apport d'une portion (table Ciqual 2025, document 4)

- Lentilles vertes cuites 150 g : énergie 150 × 125 / 100 = 187,5 kcal ; protéines 15,15 g ; fibres 12,68 g.
- Carottes 80 g : 24,2 kcal ; protéines 0,62 g ; fibres 2,32 g.
- Œuf dur 50 g : 67,0 kcal ; protéines 6,75 g ; fibres 0 g.
- Huile de colza 10 g : 90,0 kcal ; protéines 0 g ; fibres 0 g.

Total : 369 kcal ; 22,5 g de protéines ; 15,0 g de fibres.

Interprétation : la salade apporte un repas de nuit modéré en énergie (369 kcal, à compléter par du pain et un fruit ou un laitage selon la faim), riche en protéines (22,5 g) et très riche en fibres (15,0 g, soit 15,0 / 30 × 100 = 50,0 %, la moitié des 30 g par jour conseillés pour un adulte par l'ANSES). L'huile de colza apporte des acides gras oméga 3. Les fibres et les protéines prolongent la satiété, ce qui aide à éviter le distributeur.

Question 9 – Déroulé, animation et dégustation (4 pts)

Durée	Contenu	Méthode
10 min	Accueil, tour de table « ma nuit type et ce que je mange »	Interrogative, photolangage
10 min	Repères : rythme des repas en horaires décalés, caféine, hydratation, conservation	Exposé court et interactif
40 min	Réalisation en 5 binômes : lentilles, œufs, carottes, vinaigrette, houmous	Active, démonstration de la cuisson et du montage

Durée	Contenu	Méthode
15 min	Dégustation guidée et comparaison avec un produit de distributeur	Grille de dégustation, comparaison de l'étiquette
15 min	Évaluation, remise du livret, chaque agent repart avec son bocal refroidi	Questionnaire, engagement « ce que je refais cette semaine »

Grille de dégustation : aspect, couleur, odeur, goût, texture des lentilles (fondantes, non éclatées), assaisonnement, satiété ressentie, envie de refaire, notés de 1 à 4.

Question 10 – Hygiène et éco-gestes (4 pts)

Hygiène : lavage des mains et tenue ; marche en avant dans le temps (légumes terreux lavés avant le reste) ; œufs manipulés à part, mains lavées après ; refroidissement rapide des préparations cuites (de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 heures, arrêté du 21 décembre 2009) ; conservation à 4 °C au plus ; bocaux propres et étiquetés ; consommation dans les 48 heures ; réchauffage éventuel d'un plat chaud à cœur, une seule fois ; ne jamais laisser le repas à température ambiante pendant la nuit dans le vestiaire. Allergènes à signaler : œuf, moutarde, sésame (tahin du houmous).

Éco-gestes : légumineuses (protéines végétales, faible impact climatique, en cohérence avec la SNANC), bocaux et boîtes réutilisables, légumes de saison, épluchures compostées, eau de cuisson des pois chiches (aquafaba) valorisée, lave-vaisselle plein.

Question 11 – Réalisation et évaluation (4 pts)

Critères de réussite : lentilles cuites mais entières ; œufs durs sans cercle vert (pas trop cuits) ; carottes râpées fines et fraîches ; vinaigrette émulsionnée ; houmous lisse, bien assaisonné ; bocaux propres, bien montés et étiquetés ; refroidissement contrôlé et noté. Évaluation de l'atelier : satisfaction, quiz de 3 questions (durée de conservation, température du réfrigérateur, deux alternatives au distributeur), intention de refaire, nombre de bocaux préparés à la maison déclaré lors de l'atelier suivant.

Barème – Barème du sujet mixte

Temps 1 : diagnostic 4 ; objectifs et plan d'action 5 ; communication et évaluation 4 ; recherche bibliographique 3 ; éthique et sécurité numérique 2 ; expression et sources 2 ; total 20.

Temps 2 : besoins et objectifs 3 ; documents techniques et calculs 5 ; organisation, animation et dégustation 4 ; hygiène et éco-gestes 4 ; réalisation et évaluation 4 ; total 20.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Ce que je sais faire	Sujet	Acquis	En cours	À retravailler
C3.1	Qualifier une action (mode, niveau de prévention, approche, politiques)	S1, S3			
C3.1	Calculer et interpréter les indicateurs d'un diagnostic ; classer les besoins (Bradshaw)	S1, S3			
C3.1	Formuler des objectifs avec indicateur, cible et échéance	S1, S3			
C3.1	Construire un budget et un calendrier réalistes	S1, S3			
C3.1	Construire une évaluation de processus, de résultats et d'impact	S1, S3			
C3.2	Établir un bon de commande avec quantités brutes et nettes	S2, S3			
C3.2	Rédiger une fiche technique avec points critiques	S2, S3			
C3.2	Calculer un apport nutritionnel avec la table Ciqual	S2, S3			
C3.2	Adapter une texture (IDDSI) et enrichir un plat	S2			
C3.2	Organiser et animer un atelier minuté ; mener une dégustation	S2, S3			
C3.2	Appliquer l'hygiène (5 M, températures, allergènes) et les éco-gestes	S2, S3			
C3.3	Calculer un intervalle de confiance et une taille d'échantillon ; repérer les biais	S1, S3			
C3.3	Construire une équation de recherche bibliographique	S3			
C3.4	Organiser une veille et la diffuser	S1			
C3.5	Adapter la communication au public (littératie, précarité numérique, horaires)	S1, S3			
C3.6	Protéger les données et l'image des personnes ; repérer les risques numériques	S1, S3			

Modèles officiels utilisés : structure des sujets U62 (2002-2014) et E5.B (2021-2024) pour le bon de commande, la fiche technique et l'organisation ; BTS blanc CNED E5B (devoir 2) pour l'enrichissement et le calcul nutritionnel ; E5.A 2023 pour l'analyse des risques par les 5 M. Les contextes de ces sujets (centre maternel, EHPAD, enfants cœliaques, etc.) ne sont pas repris.

DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE

CHAPITRE 2

Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé

Mots-clés : Déterminants de santé, Inégalités, Mesure de l'état de santé

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 2 · Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé · version normale

1 COURS

Mise en page normale · 96 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 99

2 FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 7 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 100 à 106

3 CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 100 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 107 à 206

4 ANNALES E5

Mise en page normale · 29 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 207 à 235

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 · Cours **4**

2.1 Compétences mobilisées 7

2.2 Croisement référentiel × précisions × indications 7

2.3 Cours 9

Cas guidés : du constat à la décision 67

2.4 Approfondissements 69

2.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 75

2.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 76

2.7 L'essentiel à retenir 79

2.8 Entraînement 81

2.9 Glossaire 96

2.10 Renvois bibliographiques par notion 97

2.12 Bibliographie numérotée 97

2 · Fiche de révision et fiches-outils **100**

Fiche de révision du chapitre 2 102

1. Les définitions à savoir 102

2. Les trois modèles de déterminants 103

3. Les formules 103

4. Chiffres-clés 103

5. Les pièges 103

6. Méthode express : portrait de territoire en 6 étapes 104

7. Auto-test 104

8. Flashcards 104

Compléments du chapitre enrichi 104

Fiches-outils du chapitre 2 105

O2.1 – Grille des déterminants de l'alimentation de mon public 105

O2.2 – Tableau d'indicateurs comparés 105

O2.3 – Calcul d'un taux standardisé (méthode directe) 105

O2.4 – Repérer les inégalités dans mon projet 106

O2.5 – Grille de lecture critique d'un indicateur 106

3 · Cahier d'exercices **107**

Cahier d'exercices – Chapitre 2 110

Partie 1 – Les déterminants de santé 111

Partie 2 – Les inégalités sociales et territoriales de santé 127

Partie 3 – Les indicateurs démographiques 138

Partie 4 – Mortalité, morbidité et standardisation 149

Partie 5 – Sources de données, portrait de territoire et état nutritionnel 160

Partie 6 – Transitions et fardeau des maladies chroniques 172

Partie 7 – Mesurer une association, raisonner sur la causalité 183

Partie 8 – Représenter des données, coût de l'alimentation, agir sur les déterminants 193

Bilan : grille d'auto-évaluation 206

4 · Annales E5 ..... **207**

Cahier d'annales E5 – chapitre 2 209

Partie I – Les sujets (sans corrigé) 210

Partie II – Les corrigés détaillés 219

Grille d'auto-évaluation 235

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS

CHAPITRE

02

Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé

Déterminants de santé | Inégalités | Mesure de l'état de santé

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

2.1 Compétences mobilisées 7

2.2 Croisement référentiel × précisions × indications 7

2.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 8

2.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 8

2.3 Cours 9

2.3.1 Les déterminants de santé 10

2.3.2 Inégalités sociales et territoriales de santé 18

2.3.3 Mesurer l'état de santé : les indicateurs démographiques 26

2.3.4 Les indicateurs de mortalité et de morbidité 30

2.3.5 Les sources de données et le portrait de santé d'un territoire 37

2.3.6 Les indicateurs de l'état nutritionnel d'une population 40

2.3.7 Les transitions démographique, épidémiologique et nutritionnelle 43

2.3.8 Le fardeau des maladies chroniques liées à la nutrition en France 46

2.3.9 Mesurer l'association entre un facteur et un problème de santé 50

2.3.10 Les inégalités sociales de santé dans le champ de l'alimentation 54

2.3.11 Représenter et commenter des données épidémiologiques 56

2.3.12 Les grandes enquêtes et cohortes en nutrition 58

2.3.13 Agir sur les déterminants : leviers d'action et évaluation d'impact sur la santé 60

2.3.14 Les indicateurs de santé de la périnatalité et de l'enfance 62

2.3.15 Le coût d'une alimentation favorable à la santé 64

2.3.16 Fil rouge : le portrait de santé du quartier des Tilleuls 66

Cas guidés : du constat à la décision 67

Cas guidé 1 – Une surmortalité cardio-vasculaire 67

Cas guidé 2 – Une action a-t-elle réduit les inégalités ? 68

2.4 Approfondissements 69

2.4.1 Les déterminants commerciaux de la santé 69

2.4.2 Mesurer la défavorisation d'un territoire 70

2.4.3 Les « 1000 premiers jours » et le parcours de vie 71

2.4.4 Lire un indicateur avec un esprit critique 71

2.4.5 L'exposome et les déterminants environnementaux 72

2.4.6 Mesurer l'insécurité alimentaire 73

2.4.7 Le piège du raisonnement écologique 74

2.4.8 Santé mentale et alimentation : une relation dans les deux sens 74

2.4.9 Femmes et hommes : des écarts de santé à interpréter 75

2.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 75

2.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 76

Méthode 1 – Présenter un diagnostic de territoire à l'oral en 3 minutes 77

Méthode 2 – Répondre à une question « Calculez et interprétez » 78

Méthode 3 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve 78

2.7 L'essentiel à retenir 79

2.8 Entraînement 81

2.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 81

2.8.2 Exercices 83

2.8.3 Questions de réflexion 86

2.8.4 Étude de cas 87

2.8.5 Mises en situation express 88

2.8.6 Exercices complémentaires 90

2.8.7 Exercices de synthèse 91

2.8.8 Deuxième étude de cas 94
2.8.9 Mises en situation express complémentaires 95
2.9 Glossaire 96
2.10 Renvois bibliographiques par notion 97
2.12 Bibliographie numérotée 97

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- définir un déterminant de santé et présenter les principaux modèles (Lalonde 1974, Dahlgren et Whitehead 1991, Commission des déterminants sociaux de la santé de l'OMS 2008) ;
- identifier les déterminants de l'alimentation d'une population (individuels, socioculturels, économiques, environnementaux, politiques) ;
- définir les inégalités sociales et territoriales de santé, le gradient social, et expliquer leurs mécanismes ;
- définir et calculer les principaux indicateurs démographiques (taux de natalité, indicateur conjoncturel de fécondité, espérance de vie, espérance de vie sans incapacité, rapport de dépendance) ;
- définir et calculer les indicateurs de mortalité (taux brut, spécifique, standardisé, mortalité infantile, prématurée, évitable) et de morbidité (prévalence, incidence, affections de longue durée, recours aux soins) ;
- lire et interpréter une pyramide des âges ;
- citer les sources de données et construire le portrait de santé d'un territoire pour un diagnostic de situation (C3.1, C3.3).

2.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.1	Les données et les déterminants qui fondent le diagnostic de situation et la priorisation	Analyse et diagnostic de situation posé ; priorités et objectifs adaptés au contexte
C3.3	Les indicateurs et leurs calculs ; la lecture critique des données	Traitement et analyse des données réalisés ; contexte et problématique identifiés
C3.4	Les sources de données fiables (Insee, Drees, CépiDc, Santé publique France, ORS)	Sources d'informations fiables repérées et connues
C3.5	Présenter des données à un public non spécialiste (graphiques, chiffres clés)	Supports et contenus adaptés au public

2.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (référentiel et guide)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Déterminants : différents niveaux	Citer et illustrer les modèles de déterminants ; les appliquer à l'alimentation	Connaître Lalonde, Dahlgren et Whitehead, OMS 2008 ; pas de théorie sociologique approfondie
Inégalités sociales et territoriales de santé	Définir, illustrer par des données françaises, expliquer les mécanismes	Gradient social, universalisme proportionné, précarité alimentaire
Problèmes de santé : danger, risque, facteur de risque	Réinvestir les notions du chapitre 1 dans un diagnostic	Approfondies au chapitre 16 (épidémiologie)
Indicateurs démographiques	Définir et calculer natalité, fécondité, espérance de vie, structure par âge	Formules exigibles ; lecture d'une pyramide des âges
Indicateurs de morbidité et de mortalité	Définir et calculer taux bruts, spécifiques, standardisés ; prévalence, incidence	Standardisation directe exigible sur un exemple simple ; méthode indirecte en L3

Notion (référentiel et guide)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Organismes de recueil et de production de données	Savoir où trouver une donnée locale	Insee, Drees, CépiDc, Santé publique France (Géodes), ORS, Assurance maladie

2.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : bloc 3, savoirs « Enjeux de santé publique ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 60). Toutes les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 2.2.2.

Texte	Critère ou indication	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 60	Déterminants : différents niveaux	2.3.1 (Lalonde, Dahlgren et Whitehead, Commission de l'OMS, déterminants de l'alimentation) ; 2.3.13 (leviers d'action)
Guide 2025, p. 60	Inégalités sociales et territoriales de santé	2.3.2 (gradient social, mécanismes, territoires) ; 2.3.10 (alimentation, insécurité alimentaire, écarts absolu et relatif)
Guide 2025, p. 60	Mesure de l'état de santé : indicateurs démographiques	2.3.3 (population, natalité, fécondité, nuptialité, IDH, espérance de vie, EVSI) ; 2.3.7 (transitions, vieillissement)
Guide 2025, p. 60	Indicateurs de morbidité et de mortalité	2.3.4 (taux bruts, spécifiques, standardisés, causes de décès, prévalence, incidence) ; 2.3.6 et 2.3.14 (état nutritionnel, périnatalité)
Guide 2025, p. 60	Organismes de recueil et de production de données	2.3.5 (Insee, Drees, Inserm-CépiDc, Santé publique France, ORS, Assurance maladie) ; 2.3.12 (grandes enquêtes)
Référentiel, C3.1	Analyse et diagnostic de situation posé	2.3.5 (portrait de santé d'un territoire) ; 2.3.16 (fil rouge)
Référentiel, C3.3	Traitement et analyse des données réalisés	2.3.4, 2.3.9 et 2.3.11 (calculs, association, commentaire de données)
Référentiel, C3.4	Sources d'informations fiables repérées et connues	2.3.5 et encadré « État de la veille » (sources datées)
Référentiel, C3.5	Supports et contenus adaptés au public	2.3.11 (choisir l'échelle, cartes, rédiger un commentaire)

2.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Sources : CNED, *Environnement professionnel – Les essentiels*, 2e année (3-6124-AN-WT-00-21, © 2022), M1 S1 § 5 à 7, p. 5 à 7 ; *Synthèse du cours en bref*, 1re année (3-6123-AN-WT-00-21), M3 S1 § 1, p. 25 à 27. Toutes les notions sont reprises ; les § 1 à 4 sont traités au chapitre 1.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Essentiels M1 S1 §5 (p. 5)	Mesure de l'état de santé ; les indicateurs « produits par des organismes comme l'INSEE [...] ou encore l'INED »	2.3.3 ; 2.3.5 (organismes producteurs)
Essentiels M1 S1 §5 (p. 6)	Espérance de vie, IDH, mortalité évitable, solde naturel, taux brut de mortalité, taux d'incidence, mortalité infantile	2.3.3 (espérance de vie, solde naturel, IDH) ; 2.3.4 (taux de mortalité, mortalité prématurée et évitable, incidence) ; 2.3.14 (mortalité infantile)

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Essentiels M1 S1 §5 (p. 7)	Taux de nuptialité, de natalité, de prévalence, de fécondité	2.3.3 (natalité, fécondité, nuptialité) ; 2.3.4 (prévalence)
Essentiels M1 S1 §6 (p. 7)	Déterminants : « éléments neutres » ; facteur protecteur et facteur de risque ; quatre catégories de déterminants	2.3.1 (modèles et déterminants de l'alimentation)
Essentiels M1 S1 §7 (p. 7)	Inégalités, inégalités de santé « qui peuvent être évitées », gradient social de santé	2.3.2 (définitions, gradient, mécanismes) ; 2.3.10
Synthèse 1re année M3 S1 §1 (p. 26)	Statut pondéral des enfants et des adultes (étude INCA 3)	2.3.6 (indicateurs de l'état nutritionnel) ; 2.3.12 (INCA 3, Esteban, Albane)

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou était inexact

- **Taux brut de mortalité** (p. 6) : le fascicule le définit comme la « différence entre nombre de naissances et le nombre de décès », ce qui est la définition du **solde naturel**. Le taux brut de mortalité est le nombre de décès de l'année rapporté à la population moyenne, pour 1 000 habitants.
- **Mortalité évitable et mortalité prématurée** (p. 6) : ce sont deux indicateurs différents. La mortalité **prématurée** compte les décès avant 65 ans ; la mortalité **évitable** compte les décès (avant 75 ans dans la définition de l'OCDE et d'Eurostat) qui auraient pu être évités par la prévention ou par les soins.
- **Taux d'incidence** (p. 6) : les nouveaux cas se rapportent à la **population à risque** (sans les personnes déjà malades), et non à toute la population.
- **Indice de développement humain** (p. 6) : depuis 2010, le PNUD ne l'établit plus avec le taux d'alphabétisation, le taux brut de scolarisation et le PIB, mais avec la durée moyenne et la durée attendue de scolarisation et le revenu national brut par habitant, combinés par une moyenne géométrique.
- **Taux de fécondité** (p. 7) : la définition donnée (« nombre annuel moyen d'enfants par femme ») est celle de l'**indicateur conjoncturel de fécondité**. Le taux de fécondité rapporte les naissances au nombre de femmes de 15 à 49 ans.
- **Données mises à jour dans ce chapitre** : population, naissances, fécondité, solde naturel et espérance de vie 2025 (Insee, janvier 2026) ; espérance de vie sans incapacité à 65 ans en 2024 : 11,8 ans pour les femmes et 10,5 ans pour les hommes (Drees, janvier 2026) ; causes de décès 2024 : 641 046 décès, tumeurs 27,1 %, maladies cardio-neurovasculaires 21,2 % (Drees, Inserm-CépiDc, Santé publique France, juin 2026) ; diabète traité : plus de 3,8 millions de personnes en 2023 (Santé publique France) ; dans les annales, espérance de vie à 35 ans des cadres et des ouvriers en 2020-2022 (Insee, juillet 2024).
- **Statut pondéral** (1re année, p. 26) : les chiffres d'INCA 3 (2014-2015) restent des repères ; Esteban (2014-2016) est la dernière étude nationale avec poids et taille **mesurés** ; l'enquête déclarative OFÉO (2024) donne 18,1 % d'adultes obèses. Le dispositif Albane doit prendre le relais.

2.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Démographie** : les chiffres de ce chapitre (69,1 millions d'habitants au 1er janvier 2026, indicateur conjoncturel de fécondité de 1,56, solde naturel négatif en 2025) viennent du bilan démographique de l'Insee publié en janvier 2026 ; le bilan suivant paraît chaque année en janvier : vérifiez-le avant de citer un chiffre.
- **Causes de décès** : les dernières données consolidées portent sur l'année 2024 (Drees, *Études et résultats* n° 1375, et *BEH* n° 15, juin 2026).

- **Corpulence mesurée** : Esteban (2014-2016) reste la dernière étude nationale avec poids et taille mesurés ; le dispositif **Albane** (ANSES et Santé publique France) doit prendre le relais : vérifiez la date de ses premiers résultats.
- **Enfants et milieu social** : les données de santé scolaire par milieu social le plus souvent citées datent de 2012-2013 (grande section) ; vérifiez la parution de nouvelles enquêtes de la Drees.
- **Données déclaratives récentes** : l'étude OFÉO (2024) donne 18,1 % d'adultes déclarant un IMC ≥ 30 ; ne la comparez pas directement à des données mesurées.

2.3.1 Les déterminants de santé

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §6 (p. 7)

Définition – Déterminant de santé

Facteur personnel, social, économique, environnemental ou politique qui **influence l'état de santé** d'une personne ou d'une population (OMS, glossaire de la promotion de la santé, 1998). Un déterminant peut être **favorable** (facteur de protection) ou **défavorable** (facteur de risque) ; il peut être **modifiable** (alimentation, revenus, logement) ou **non modifiable** (âge, sexe, génétique).

Comprendre les déterminants, c'est répondre à la question « **pourquoi** ce problème de santé est-il plus fréquent dans ce groupe ? ». C'est l'étape qui transforme un constat (« 14 % des enfants de l'école sont en surpoids ») en diagnostic (« … parce que l'offre alimentaire du quartier est pauvre, que les revenus sont faibles, que les espaces de jeu manquent… ») et qui permet de choisir **sur quoi agir**.

Classer les déterminants : cinq distinctions utiles

Avant de présenter les modèles, il faut savoir qualifier un déterminant. Le jury attend un vocabulaire précis.

Distinction	Définition	Exemple en nutrition
Modifiable ou non modifiable	Le déterminant peut-il changer par une action ?	Modifiable : prix des fruits, offre de la cantine. Non modifiable : âge, sexe, hérédité
Individuel ou collectif	Il concerne une personne ou un groupe entier	Individuel : compétences culinaires. Collectif : implantation des commerces d'un quartier
Proximal ou distal	Il agit directement sur la santé (proche) ou en amont, à travers d'autres facteurs (éloigné)	Proximal : apport en sel. Distal : prix des produits transformés, revenu minimum
Facteur de risque ou de protection	Il augmente ou diminue la probabilité d'un problème de santé	Risque : boissons sucrées. Protection : allaitement, activité physique
Structurel ou intermédiaire	Il crée la position sociale, ou il traduit cette position en conditions de vie	Structurel : niveau d'études. Intermédiaire : logement sans cuisine

Définition – Facteur de risque et facteur de protection

Un **facteur de risque** est une caractéristique, une exposition ou un comportement associé à une **probabilité plus élevée** de survenue d'un problème de santé. Un **facteur de protection** est associé à une probabilité **plus faible**. Un facteur de risque n'est pas une cause certaine : toutes les personnes exposées ne tombent pas malades, et des personnes non exposées peuvent l'être (chapitre 1).

Pourquoi les déterminants non médicaux comptent autant : deux études historiques

La thèse de McKeown (1976). Le médecin britannique Thomas McKeown a montré que la mortalité par tuberculose avait fortement baissé en Angleterre et au pays de Galles **bien avant** la découverte du bacille (1882), de l'antibiotique streptomycine (1947) et du vaccin BCG. Il a attribué l'essentiel de cette baisse à l'**amélioration de l'alimentation** et des conditions de vie. Sa thèse a été discutée (le rôle de l'hygiène publique et de l'eau potable a été réévalué), mais elle a durablement montré que la médecine n'est pas le seul déterminant de la santé d'une population.

Les études de Whitehall (à partir de 1967). Michael Marmot a suivi des milliers de fonctionnaires britanniques, tous salariés, tous couverts par le système de santé. La mortalité était plus élevée à chaque échelon inférieur de la hiérarchie administrative, même entre des groupes qui n'étaient pas pauvres : c'est la découverte du **gradient social de santé**. Le tabac, la tension artérielle et le cholestérol n'expliquaient qu'une partie de l'écart ; le faible contrôle sur son travail et le stress psychosocial en expliquaient une autre partie.

À retenir – Ce qu'il faut savoir citer

- **Lalonde (1974)** : la santé dépend de quatre champs, pas seulement des soins.
- **McKeown (1976)** : la baisse historique de la mortalité vient d'abord des conditions de vie et de l'alimentation.
- **Whitehall (Marmot, à partir de 1967)** : il existe un gradient social de santé, même chez des personnes qui ont un emploi stable.
- **Dahlgren et Whitehead (1991)** : les comportements sont enchâssés dans les conditions de vie.
- **CDSS de l'OMS (2008)** : les déterminants structurels produisent les inégalités.

Le modèle de Lalonde (1974)

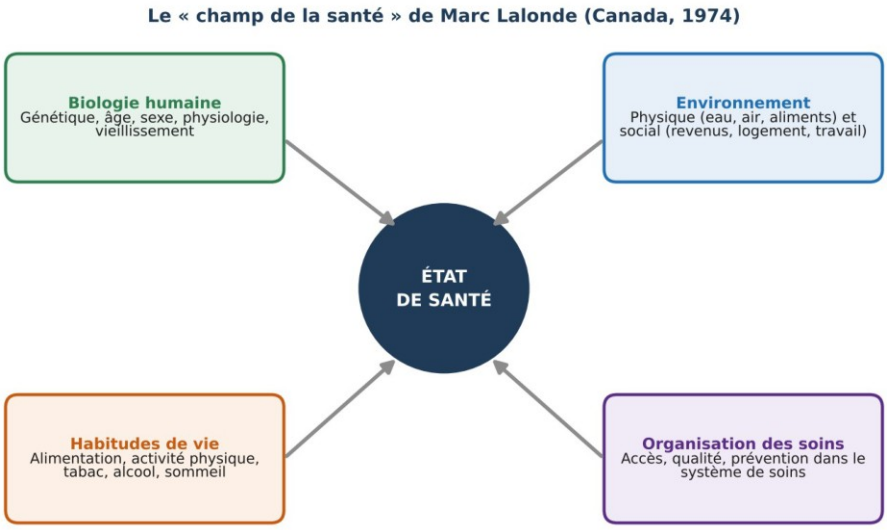


Figure 2.1 – Le « champ de la santé » selon Marc Lalonde (1974)

Comprendre le schéma – Figure 2.1

1. Au centre, l'**état de santé** d'une population.

2. Biologie humaine : patrimoine génétique, âge, sexe, processus de vieillissement.

3. Environnement : tout ce qui est extérieur au corps et sur quoi la personne a peu de contrôle (qualité de l'air, de l'eau, des aliments ; environnement social).

4. Habitudes de vie : décisions individuelles qui influencent la santé (alimentation, activité physique, tabac, alcool).

5. Organisation des soins : quantité, qualité, accessibilité des services de santé.

6. Message du rapport : la quasi-totalité des dépenses de santé allait aux soins, alors que les trois autres champs pèsent davantage sur la mortalité. Limite : le modèle a parfois été utilisé pour **responsabiliser l'individu** (« habitudes de vie ») sans tenir compte des conditions sociales.

Le modèle de Dahlgren et Whitehead (1991)

Présenté au chapitre 1 (figure 1.5), ce modèle « arc-en-ciel » organise les déterminants en **couches concentriques** : facteurs individuels (âge, sexe, hérédité) ; style de vie ; réseaux sociaux et communautaires ; conditions de vie et de travail (dont **agriculture et production alimentaire**, éducation, emploi, logement, eau, services de santé) ; conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales. Il montre que les comportements individuels sont **enchâssés** dans des conditions de vie qui les rendent plus ou moins faciles.

Le cadre de la Commission des déterminants sociaux de la santé (OMS, 2008)

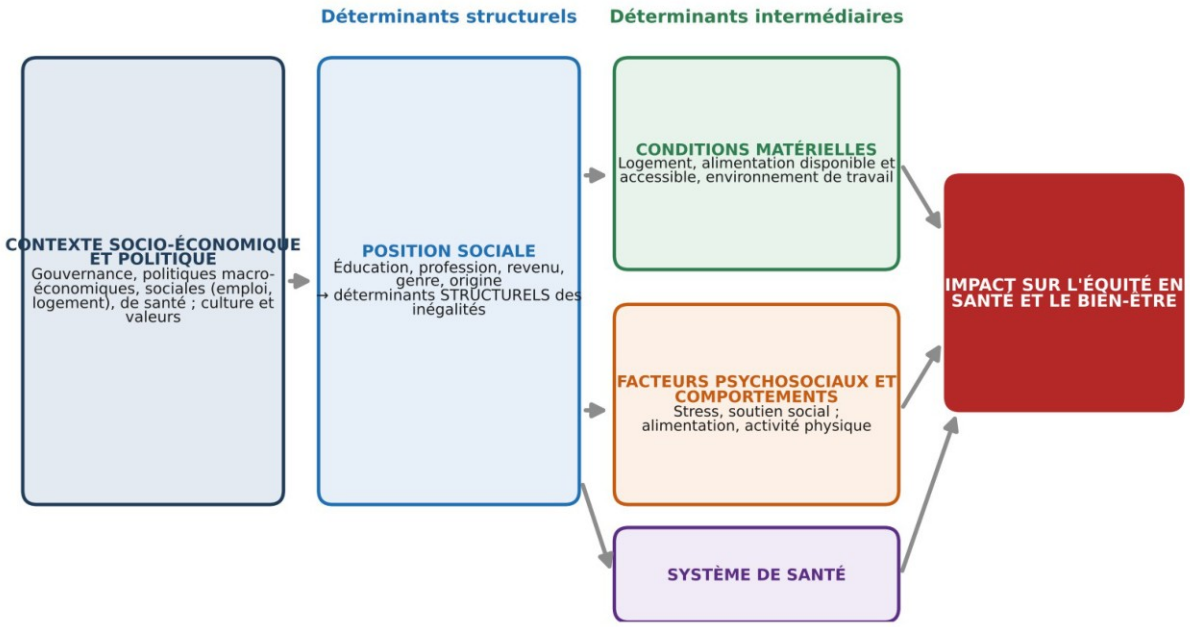


Figure 2.2 – Cadre conceptuel des déterminants sociaux de la santé (OMS, Solar et Irwin, 2010)

Comprendre le schéma – Figure 2.2

1. Contexte socio-économique et politique : gouvernance, politiques économiques, sociales (emploi, logement, protection sociale), politiques de santé, culture et valeurs d'une société.

2. Position sociale : niveau d'éducation, profession, revenu, genre, origine. Avec le contexte, ce sont les **déterminants structurels** : ils produisent la stratification sociale, donc les inégalités.

3. Déterminants intermédiaires : les conditions **matérielles** (logement, alimentation accessible, conditions de travail), les facteurs **psychosociaux** (stress, soutien social) et les **comportements** (alimentation, activité physique), ainsi que le **système de santé**.

4. À droite, l'**impact** sur l'équité en santé et le bien-être. Les flèches montrent que la position sociale agit sur la santé **à travers** les déterminants intermédiaires.

5. Conséquence pratique : une action limitée aux comportements (intermédiaires) ne corrige pas les inégalités produites par les déterminants structurels ; il faut aussi agir sur les conditions de vie et les politiques.

Les déterminants de l'alimentation

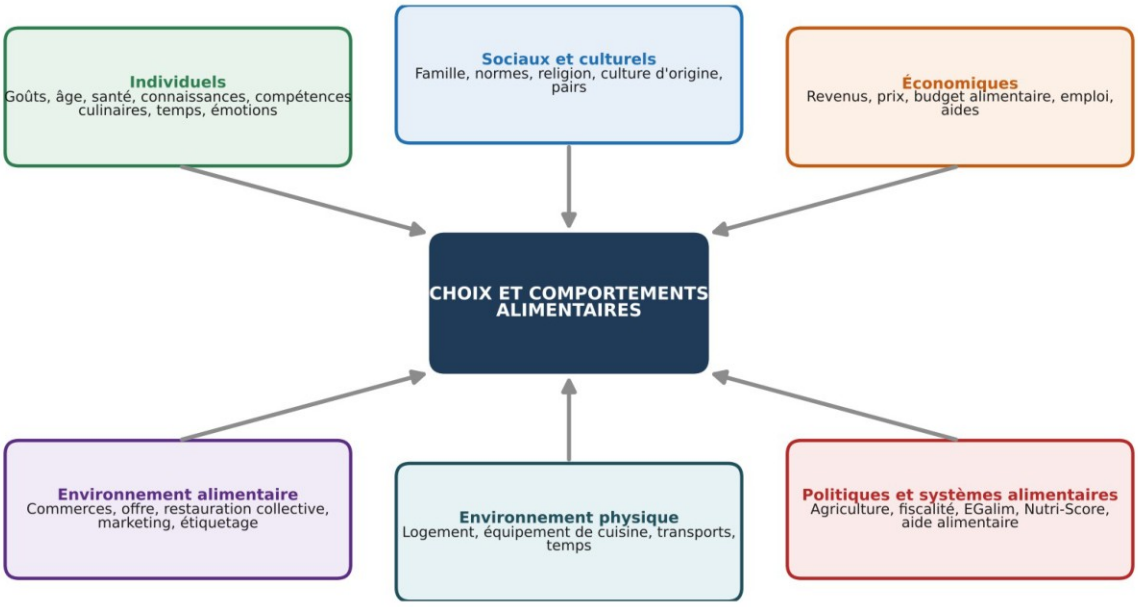


Figure 2.3 – Les déterminants des choix et comportements alimentaires

Comprendre le schéma – Figure 2.3

1. Au centre, les **choix et comportements alimentaires** d'une personne ou d'un groupe.

2. Individuels : préférences, âge, état de santé, connaissances, compétences culinaires, temps disponible, émotions (chapitres 3 et 4).

3. Sociaux et culturels : habitudes familiales, normes du groupe, culture d'origine, religion, influence des pairs.

4. Économiques : revenus, prix relatifs des aliments, part du budget consacrée à l'alimentation, aides (épicerie solidaire, chèques alimentaires).

5. Environnement alimentaire : présence et type de commerces (supermarché, supérette, restauration rapide), offre de la restauration collective, marketing, étiquetage (Nutri-Score).

6. Environnement physique : logement (cuisine équipée ou non, réfrigérateur), transports, horaires de travail.

7. Politiques et systèmes alimentaires : agriculture, fiscalité, lois (EGalim), aide alimentaire, programmes (PNNS 5, PNA 4).

Définition – Environnement alimentaire

Ensemble des conditions physiques, économiques, politiques et socioculturelles qui déterminent la **disponibilité**, l'**accessibilité** (physique et financière), l'**attractivité** et la **qualité** des aliments auxquels les personnes ont accès dans leur vie quotidienne (domicile, quartier, école, travail). On parle de **« déserts alimentaires »** (zones où l'accès physique à des aliments frais est difficile) et de **« marais alimentaires »** (zones saturées d'offre de restauration rapide et d'aliments peu favorables à la santé).

Exemple – Analyser les déterminants d'un problème : la faible consommation de fruits et légumes dans une résidence

étudiante

- **Individuels** : peu de temps, faibles compétences culinaires, préférence pour les plats rapides.
- **Sociaux** : repas pris seul, normes étudiantes (« soirées », grignotage).

- **Économiques** : bourse ou petit job, loyer élevé : l'alimentation devient la variable d'ajustement du budget.
- **Environnement alimentaire** : restaurant universitaire éloigné, supérette chère, livraison de repas omniprésente.
- **Environnement physique** : kitchenette sans four, réfrigérateur partagé.
- **Politiques** : repas à 1 € au restaurant universitaire pour les étudiants boursiers et précaires, épiceries solidaires étudiantes.

Leviers possibles : paniers de fruits et légumes à prix réduit sur le campus (milieu favorable), ateliers « cuisiner en kitchenette » (aptitudes), information sur les aides (accès), plaidoyer pour un point de vente au campus (politique).

À vous de jouer – Exercice d'application 2.1

Pour la situation suivante, classez chaque élément selon les 5 couches du modèle de Dahlgren et Whitehead : « Mme T., 72 ans, veuve, vit seule au 4e étage sans ascenseur dans un village sans commerce ; elle a une petite retraite ; ses enfants vivent loin ; elle a une arthrose du genou ; elle a arrêté de cuisiner depuis le décès de son mari ; le portage de repas n'existe pas dans sa commune. »

Corrigé

1. Facteurs individuels : 72 ans, femme, arthrose (vieillissement).

2. Style de vie : arrêt de la cuisine, alimentation probablement monotone.

3. Réseaux sociaux et communautaires : veuvage, enfants éloignés, isolement.

4. Conditions de vie : logement au 4e étage sans ascenseur, absence de commerce et de portage de repas (services), faibles revenus (retraite).

5. Conditions générales : politiques de l'autonomie et du vieillissement, désertification commerciale rurale, montant des pensions. **Conclusion** : le risque de dénutrition de Mme T. ne relève pas d'un « mauvais choix » individuel ; les leviers sont d'abord le lien social (repas partagés, visites), les services (portage de repas, transport) et l'adaptation du logement.

Comparer les trois modèles de déterminants

Critère	Lalonde (1974)	Dahlgren et Whitehead (1991)	CDSS de l'OMS (2008)
Forme	Quatre champs côte à côte	Couches concentriques (« arc-en-ciel »)	Schéma de causalité avec des flèches
Idée forte	Les soins ne sont qu'un champ parmi quatre	Les comportements dépendent des conditions de vie	La position sociale agit à travers les déterminants intermédiaires
Place des inégalités	Absente	Implicite	Centrale (équité en santé)
Limite	Risque de culpabiliser l'individu (« habitudes de vie »)	Ne montre pas les liens de cause entre couches	Plus complexe à présenter à un public
Usage pour le diététicien	Présentation simple à des élus ou à des élèves	Analyse des déterminants d'un public ; choix du niveau d'action	Argumenter une action qui réduit les inégalités

Figure 2.1 ter – Le champ de la santé de Lalonde, version détaillée

Comprendre le schéma – Figure 2.1 ter

1. Au centre, l'**état de santé**, influencé par quatre champs de même taille.
2. **Biologie humaine** (génétique, âge, sexe, fonctionnement du corps) et **environnement** (physique et social : logement, travail, revenus).
3. **Habitudes de vie** (alimentation, activité physique, tabac, alcool) et **organisation des soins** (accès, qualité et quantité des soins).
4. Comparez avec la figure suivante : chez Lalonde, les champs sont juxtaposés ; chez Dahlgren et Whitehead, ils sont emboîtés.

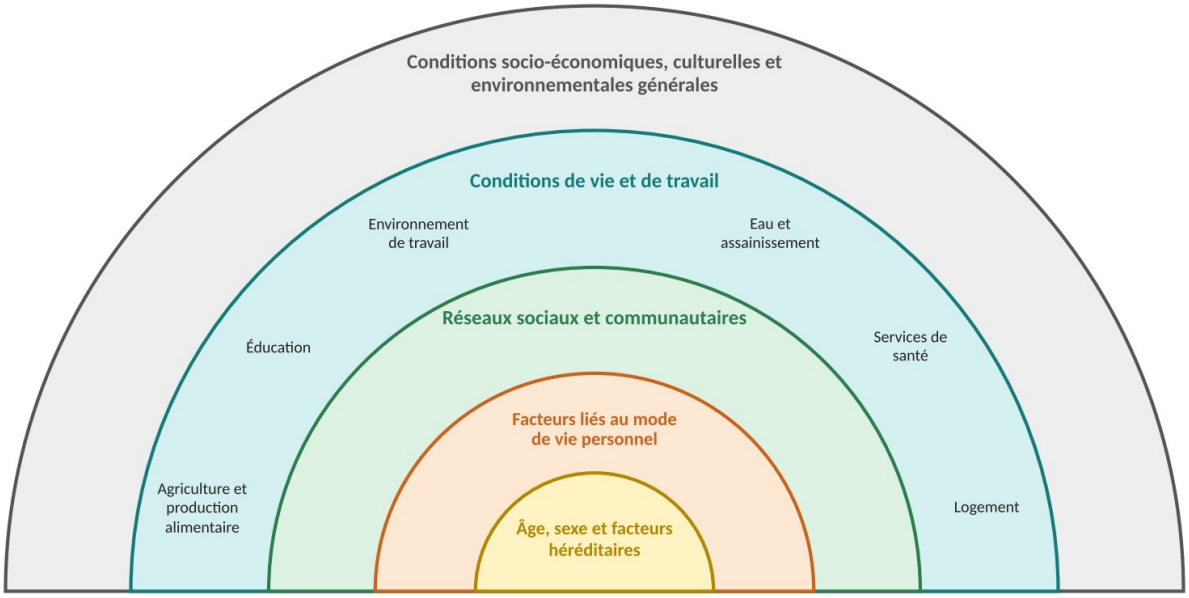


Figure 2.1 bis – Le modèle de Dahlgren et Whitehead, version détaillée

Comprendre le schéma – Figure 2.1 bis

1. Au centre, l'**âge, le sexe et les facteurs héréditaires**, non modifiables.
2. Autour, les **facteurs liés au mode de vie personnel** : alimentation, activité physique, tabac, alcool.
3. Puis les **réseaux sociaux et communautaires** : famille, amis, voisinage, associations.
4. Puis les **conditions de vie et de travail**, présentées en secteurs : agriculture et production alimentaire, éducation, environnement de travail, chômage, eau et assainissement, services de santé, logement.
5. À l'extérieur, les **conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales** : économie, politiques publiques, culture, climat.
6. Lecture : plus on agit sur une couche extérieure, plus l'action touche de personnes, et moins elle dépend de la volonté de chacun.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.1 bis

Qualifiez chaque déterminant selon les cinq distinctions du tableau (modifiable ou non, individuel ou collectif, proximal ou distal, risque ou protection, structurel ou intermédiaire) : a) l'absence de réfrigérateur dans un logement ; b) le niveau de diplôme de la mère ; c) la consommation quotidienne de sodas ; d) une taxe sur les boissons sucrées ; e) l'âge de 85 ans.

Corrigé

a) Modifiable, individuel (lié au logement de la personne), distal par rapport à la santé (il agit à travers l'alimentation), facteur de risque, intermédiaire (condition matérielle). b) Peu modifiable à l'âge adulte, individuel, distal, facteur de risque quand il est faible, structurel (position sociale). c) Modifiable, individuel, proximal, facteur de risque, intermédiaire (comportement). d) Modifiable, collectif, distal, facteur de protection, structurel (contexte politique). e) Non modifiable, individuel, facteur de risque (de dénutrition, de maladies chroniques) ; l'âge sert surtout à **cibler** une action.

Méthode : analyser les déterminants de l'alimentation d'un public

Méthode pas à pas – La grille en 4 étapes

1. Partir du problème observé, formulé sans jugement : « Les familles consomment peu de légumes », et non « les familles mangent mal ».

2. Recueillir les déterminants par l'observation, les entretiens et les données, famille par famille de déterminants : individuels, sociaux et culturels, économiques, environnement alimentaire, environnement physique, politiques.

3. Distinguer les freins et les ressources : chaque famille de déterminants contient aussi des points d'appui (savoir-faire culinaires, entraide, marché proche).

4. Choisir les leviers : pour chaque frein important, un levier réaliste, en précisant qui peut agir (le diététicien seul ou avec des partenaires).

Exemple – Grille remplie : familles d'un quartier prioritaire et consommation de légumes (données d'observation fictives)

Déterminants	Freins	Ressources	Leviers possibles
Individuels	Peu de temps le soir ; enfants qui refusent les légumes	Parents motivés pour la santé de leurs enfants	Recettes rapides ; dégustations répétées pour les enfants
Sociaux et culturels	Repas pris devant la télévision ; habitudes de plats en sauce	Savoir-faire culinaires variés selon les origines	Ateliers où les habitants partagent leurs recettes de légumes
Économiques	Budget serré ; peur du gaspillage	Aides alimentaires disponibles	Légumes surgelés nature, soupes, paniers à prix réduit
Environnement alimentaire	Supérette avec peu de légumes frais	Marché le samedi	Partenariat avec le marché ; vente de paniers au centre social
Environnement physique	Petite cuisine, pas de four dans certains logements	Cuisine pédagogique au centre social	Recettes à la poêle ou au micro-ondes
Politiques	Méconnaissance des aides	Projet alimentaire territorial en cours	Information sur les droits ; inscription des ateliers dans le PAT

Lecture : la plupart des leviers ne relèvent pas de la seule information. Le diététicien conçoit les ateliers et les recettes ; il a besoin du centre social, du marché, du CCAS et de la collectivité pour les leviers économiques et environnementaux.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.1 ter

Remplissez une grille de déterminants (freins, ressources, leviers) pour le problème suivant : « Les résidents d'un foyer de jeunes travailleurs sautent souvent le petit-déjeuner. » Données : horaires de travail décalés, cuisine collective ouverte de 7 h à 22 h, budget limité, beaucoup de jeunes arrivés récemment dans la ville, une boulangerie au rez-de-chaussée.

Corrigé

Individuels : fatigue, manque d'appétit le matin (frein) ; jeunes autonomes (ressource) ; levier : idées de petits-déjeuners à emporter. Sociaux : isolement des nouveaux arrivants (frein) ; vie collective du foyer (ressource) ; levier : petit-déjeuner partagé une fois par semaine. Économiques : budget limité (frein) ; levier : achats groupés de produits de base (pain, lait, fruits). Environnement physique : cuisine fermée avant certains départs très matinaux (frein) ; levier : ouverture plus tôt ou coin petit-déjeuner accessible. Environnement

alimentaire : boulangerie au rez-de-chaussée (ressource à double tranchant, viennoiseries) ; levier : formule petit-déjeuner équilibrée négociée. Politiques : règlement intérieur du foyer ; levier : l'adapter avec la direction.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 2.3.1 – Les déterminants de santé

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez la définition d'un déterminant de santé et sa source.
2. Citez les quatre champs du modèle de Lalonde et l'année du rapport.
3. Rangez de l'intérieur vers l'extérieur les cinq couches du modèle de Dahlgren et Whitehead.
4. Distinguez déterminant structurel et déterminant intermédiaire, avec un exemple de chaque.
5. Vrai ou faux : « Un désert alimentaire est une zone où il n'y a aucun commerce. » Justifiez.
6. Qu'a montré l'étude de Whitehall ?

Corrigé – Point d'étape 2.3.1

1. Facteur personnel, social, économique, environnemental ou politique qui influence l'état de santé d'une personne ou d'une population (OMS, glossaire de la promotion de la santé, 1998).
2. Biologie humaine, environnement, habitudes de vie, organisation des soins ; rapport Lalonde, Canada, 1974.
3. Âge, sexe et hérédité ; mode de vie personnel ; réseaux sociaux et communautaires ; conditions de vie et de travail ; conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales.
4. Structurel : produit la position sociale (revenu, diplôme, politiques sociales). Intermédiaire : traduit cette position en conditions de vie et comportements (logement sans cuisine, stress, consommation de fruits).
5. Faux : c'est une zone où l'accès physique aux aliments frais est difficile ; il peut y avoir des commerces, mais pas de produits frais à distance raisonnable.
6. Un gradient social de mortalité chez des fonctionnaires britanniques tous salariés : la mortalité augmente à chaque échelon inférieur de la hiérarchie.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

2.3.2 Inégalités sociales et territoriales de santé

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §7 (p. 7)

Définition – Inégalités sociales de santé (ISS)

Différences d'état de santé **systématiques**, **socialement produites** (donc **évitables**) et **injustes** entre groupes sociaux (définis par le revenu, le niveau d'études, la profession, le genre, l'origine ou le territoire). Toute différence de santé n'est pas une inégalité sociale : la différence d'espérance de vie entre hommes et femmes a une part biologique ; la différence entre cadres et ouvriers est une inégalité sociale.

Définition – Gradient social de santé

Les inégalités ne concernent pas seulement les plus pauvres : l'état de santé **s'améliore progressivement à chaque échelon** de l'échelle sociale. Chaque groupe a une santé moins bonne que le groupe immédiatement

au-dessus de lui. C'est pourquoi l'action ne peut pas se limiter aux personnes en grande précarité (principe d'**universalisme proportionné**, chapitre 1).

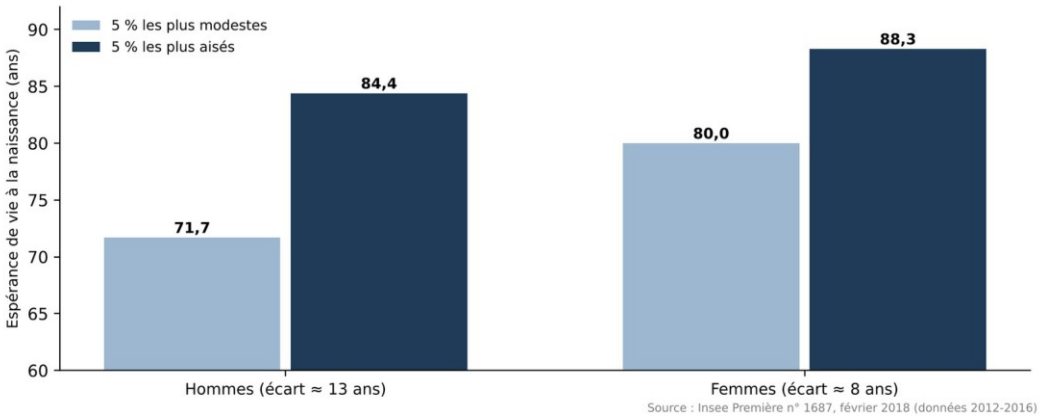


Figure 2.4 – Espérance de vie à la naissance selon le niveau de vie (France, 2012-2016)

Comprendre le schéma – Figure 2.4

1. Les barres claires représentent les 5 % de personnes les plus modestes ; les barres foncées les 5 % les plus aisées.
2. Chez les **hommes**, l'écart atteint environ **13 ans** (71,7 ans contre 84,4 ans).
3. Chez les **femmes**, l'écart est d'environ **8 ans** (80,0 ans contre 88,3 ans).
4. L'étude de l'Insee montre aussi que l'espérance de vie augmente **régulièrement** avec le niveau de vie : c'est le gradient social. Autour de 1 000 euros par mois, 100 euros de plus de niveau de vie sont associés à 0,9 an d'espérance de vie en plus chez les hommes.

Égalité, équité, iniquité : les mots justes

Définition – Égalité et équité en santé

- L'**égalité** consiste à donner la **même chose à tous** (la même brochure, le même atelier, le même tarif).
- L'**équité** consiste à donner à chacun **selon ses besoins**, pour que tous aient les mêmes chances d'être en bonne santé. Une action équitable peut donc être **inégale** dans ses moyens : plus d'ateliers dans le quartier prioritaire.
- Une **iniquité** en santé est, selon Margaret Whitehead (OMS Europe, 1990), une différence de santé qui est **non nécessaire**, **évitable**, et de plus considérée comme **injuste**.

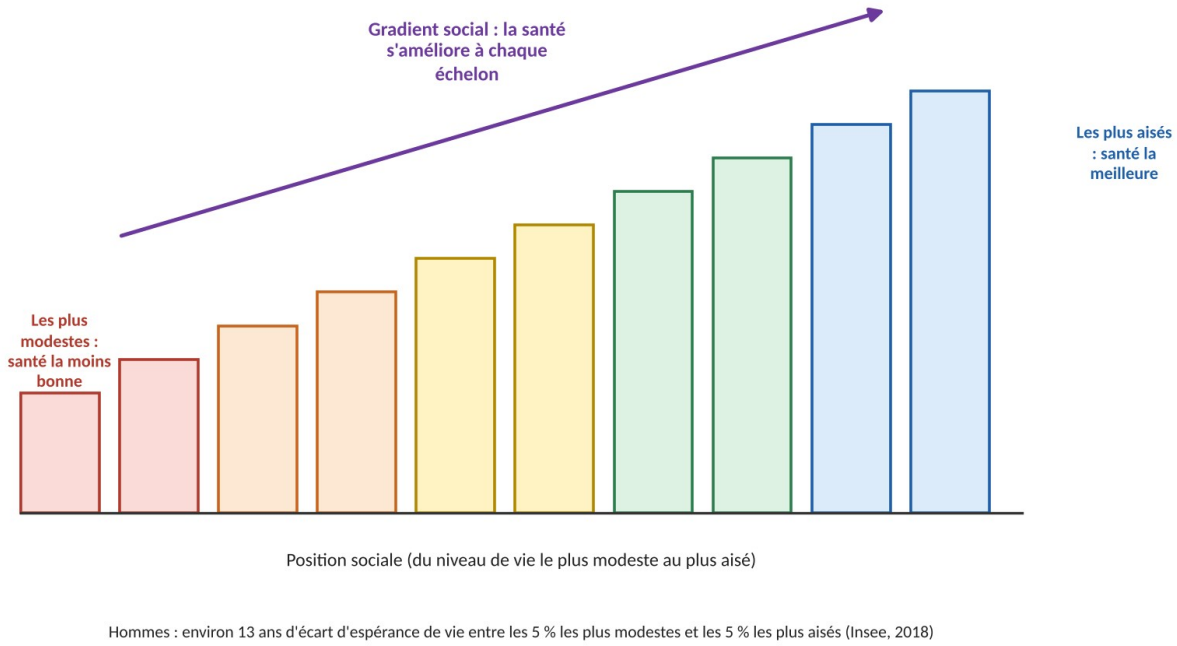


Figure 2.4 bis – Le gradient social de santé

Comprendre le schéma – Figure 2.4 bis

1. En abscisse, la **position sociale**, du niveau de vie le plus modeste au plus aisé.
2. En ordonnée, un indicateur de santé (espérance de vie, santé perçue).
3. La santé s'améliore à **chaque échelon** : ce n'est pas une marche entre « pauvres » et « non pauvres », mais une pente régulière.
4. La note rappelle l'ordre de grandeur français : chez les hommes, environ 13 ans d'écart d'espérance de vie entre les 5 % les plus modestes et les 5 % les plus aisés (Insee, 2018).
5. Conséquence : une action réservée aux plus pauvres laisse de côté une grande partie du gradient ; une action identique pour tous profite d'abord aux plus aisés ; d'où l'**universalisme proportionné**.

Mesurer la position sociale d'une personne

Pour étudier les inégalités, il faut d'abord classer les personnes selon leur position sociale. Aucun indicateur n'est parfait ; on en combine souvent plusieurs.

Indicateur	Ce qu'il mesure	Intérêt et limite
Professions et catégories socioprofessionnelles (PCS 2020, Insee)	Le groupe social selon le métier (agriculteurs, artisans et commerçants, cadres, professions intermédiaires, employés, ouvriers)	Classique et comparable ; mal adapté aux personnes sans emploi, aux étudiants, aux retraités
Diplôme	Le niveau d'études le plus élevé	Stable à l'âge adulte, facile à recueillir ; lié à la littératie en santé
Revenu et niveau de vie	Les ressources du ménage, rapportées à sa taille	Le plus direct ; question souvent refusée ou imprécise
Score EPICES	Précarité, à partir de 11 questions simples (mutuelle, propriétaire, difficultés financières, sorties, soutien familial…)	Utilisé par les centres d'examens de santé de l'Assurance maladie ; repère des personnes précaires non repérées par le revenu

Indicateur	Ce qu'il mesure	Intérêt et limite
Couverture sociale	Complémentaire santé solidaire, aide médicale de l'État	Disponible dans les données de l'Assurance maladie ; ne repère que les personnes qui ont ouvert leurs droits

Définition – Niveau de vie et unités de consommation

Le **niveau de vie** est le revenu disponible du ménage (après impôts et prestations sociales) divisé par le nombre d'**unités de consommation** (UC). Les UC tiennent compte des économies d'échelle d'un ménage : selon l'échelle de l'OCDE modifiée, utilisée par l'Insee, le premier adulte compte pour **1 UC**, chaque autre personne de 14 ans ou plus pour **0,5 UC**, chaque enfant de moins de 14 ans pour **0,3 UC**. Le **seuil de pauvreté** est fixé à **60 % du niveau de vie médian** ; le **taux de pauvreté** est la part des personnes qui vivent sous ce seuil (14 à 15 % de la population en France selon l'Insee ; vérifiez la dernière publication).

Calcul détaillé – Comparer le niveau de vie de trois ménages (données fictives, par mois)

- **Ménage A** : couple avec deux enfants de 15 ans et 9 ans ; revenu disponible 2 760 €. UC = 1 + 0,5 + 0,5 + 0,3 = **2,3**. Niveau de vie = 2 760 / 2,3 = **1 200,00 €**.
- **Ménage B** : mère seule avec deux enfants de 4 ans et 7 ans ; revenu disponible 1 650 €. UC = 1 + 0,3 + 0,3 = **1,6**. Niveau de vie = 1 650 / 1,6 = **1 031,25 €**.
- **Ménage C** : couple sans enfant ; revenu disponible 1 890 €. UC = 1 + 0,5 = **1,5**. Niveau de vie = 1 890 / 1,5 = **1 260,00 €**.

Interprétation : le ménage A a le revenu le plus élevé (2 760 €) mais pas le niveau de vie le plus élevé ; le ménage B, avec le revenu le plus faible et trois personnes, a le niveau de vie le plus bas. Pour comparer des familles, on raisonne toujours en **niveau de vie** et non en revenu. Les familles monoparentales sont surreprésentées parmi les ménages pauvres : c'est un public prioritaire fréquent des actions d'aide alimentaire.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.1 quater

Un père seul vit avec ses trois enfants de 16 ans, 12 ans et 8 ans ; son revenu disponible est de 2 300 € par mois. a) Calculez le nombre d'unités de consommation et le niveau de vie. b) Pour l'exercice, on retient un seuil de pauvreté de 1 250 € par mois (valeur arrondie et fictive) : ce ménage est-il pauvre ? c) Pourquoi le diététicien doit-il connaître cette notion ?

Corrigé

a) UC = 1 (père) + 0,5 (16 ans) + 0,3 (12 ans) + 0,3 (8 ans) = **2,1** ; niveau de vie = 2 300 / 2,1 = **1 095,24 €** par mois. **b)** 1 095,24 € est inférieur au seuil de 1 250 € : les membres de ce ménage vivent **sous le seuil de pauvreté**. **c)** Le budget alimentaire des ménages pauvres est la variable d'ajustement de leurs dépenses : les conseils doivent être compatibles avec ce budget (coût par portion, produits de base, aides alimentaires), et les actions doivent tenir compte de l'accès financier, pas seulement des connaissances.

Comment les inégalités sociales se construisent : les mécanismes

- **Matériels** : logement (humidité, surpeuplement, absence de cuisine), revenus, accès à une alimentation de qualité, conditions de travail pénibles.
- **Psychosociaux** : stress chronique lié à la précarité, faible contrôle sur sa vie, isolement, discriminations ; le stress influence aussi les comportements alimentaires.

- **Comportementaux** : tabagisme, sédentarité, alimentation déséquilibrée plus fréquents dans les milieux défavorisés, mais eux-mêmes déterminés par les conditions de vie (le prix au kilo des aliments denses en énergie est plus bas).
- **Accès aux soins et à la prévention** : renoncement aux soins, moindre recours au dépistage, littératie en santé plus faible (chapitre 5).
- **Parcours de vie** : les désavantages s'**accumulent** dès les « 1000 premiers jours » (de la conception aux 2 ans de l'enfant) et se transmettent entre générations.

Quatre explications classiques : le rapport Black (1980)

Au Royaume-Uni, le rapport Black (1980) a été le premier grand rapport officiel sur les inégalités sociales de santé. Il a proposé quatre explications, toujours utiles pour raisonner.

Explication	Idée	Ce qu'on en retient aujourd'hui
Artefact	Les inégalités seraient une illusion due à la façon de mesurer (catégories sociales mal définies)	Rejetée : les écarts persistent avec tous les indicateurs (revenu, diplôme, profession, défavorisation du quartier)
Sélection par la santé	Une mauvaise santé ferait descendre dans l'échelle sociale (perte d'emploi, de revenus)	Existe, mais n'explique qu'une petite partie des écarts ; elle joue surtout pour les maladies graves et le handicap
Culturelle et comportementale	Les groupes modestes auraient des comportements moins favorables (tabac, alimentation, sédentarité)	Explique une partie des écarts, mais les comportements dépendent eux-mêmes des conditions de vie : expliquer par les seuls « choix » culpabilise
Matérialiste et structurelle	Les conditions matérielles (revenu, logement, travail, environnement) produisent les écarts	Explication principale, reprise par la CDSS de l'OMS (2008) avec les déterminants structurels

Attention – Le piège de l'explication par les comportements seuls

Dire « les personnes modestes sont plus souvent obèses parce qu'elles mangent mal » est incomplet et stigmatisant. Il faut ajouter **pourquoi** : prix par calorie plus bas des produits denses en énergie, offre alimentaire du quartier, horaires de travail, stress, équipement du logement, littératie en santé. Le jury attend cette chaîne explicative.

Exemple – Rédiger une chaîne explicative complète

« Le surpoids des enfants est plus fréquent dans les familles ouvrières (16 % contre 7 % chez les enfants de cadres en grande section, Drees, données 2012-2013). Cet écart s'explique d'abord par les **conditions matérielles** : budget alimentaire contraint, logements plus petits, moins d'accès aux activités sportives payantes. Ces conditions influencent les **comportements** : boissons sucrées et produits denses en énergie moins chers par calorie, plus de temps d'écran. Le **stress** lié à la précarité et la **littératie** en santé jouent aussi. Une action efficace doit donc agir sur l'accès (prix, offre de la cantine, activités gratuites) autant que sur les connaissances. »

Quelques données françaises

Indicateur	Donnée (source)
Espérance de vie selon le niveau de vie	≈ 13 ans d'écart chez les hommes et 8 ans chez les femmes entre les 5 % les plus aisés et les 5 % les plus modestes (Insee, 2018)
Obésité selon la situation économique	24,7 % chez les adultes déclarant des difficultés économiques contre 18,1 % pour l'ensemble (OFÉO, 2024)

Indicateur	Donnée (source)
Précarité alimentaire	16 % des Français déclarent ne pas avoir toujours assez à manger (Crédoc, 2022)
Activité physique	La pratique régulière d'une activité de loisir est plus fréquente chez les catégories socioprofessionnelles favorisées ; 40,2 % des adultes déclarent une pratique régulière (Baromètre de Santé publique France 2024)
Littératie en santé	44 % des adultes ont une littératie problématique ou insuffisante ; les difficultés sont plus fréquentes chez les personnes peu diplômées ou à faibles revenus (HLS19 France, Santé publique France)

Les inégalités territoriales de santé

Les inégalités ont aussi une dimension **géographique** : à niveau social comparable, vivre dans certains territoires expose à plus de risques. En France, la mortalité est plus élevée dans le **nord et le nord-est** de l'Hexagone et surtout dans les **départements et régions d'outre-mer** (en 2023, la mortalité standardisée dépasse de 89 % la moyenne nationale à Mayotte et de 37 % en Guyane ; Inserm-CépiDc, 2025). L'obésité de l'adulte atteint 22,4 % en outre-mer contre 17,9 % dans l'Hexagone (OFÉO, 2024). À l'échelle locale, les **quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)** et certains **territoires ruraux** cumulent faibles revenus, offre alimentaire et de soins réduite et difficultés de transport.

Définition – Précarité et insécurité alimentaires

- L'**insécurité alimentaire** désigne la situation des personnes qui n'ont pas un accès régulier à suffisamment d'aliments sûrs et nutritifs pour une croissance et un développement normaux et une vie active et saine (FAO) ; elle se mesure notamment avec l'échelle FIES (*Food Insecurity Experience Scale*).
- En France, la **lutte contre la précarité alimentaire** est définie par la loi EGalim (article L. 266-1 du Code de l'action sociale et des familles) : elle vise à favoriser l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, dans le respect de leur dignité et en développant leurs capacités à agir pour elles-mêmes.

Lien diététique – Ce que cela change pour le diététicien

- Dans un diagnostic, présenter **systématiquement** les données sociales et territoriales à côté des données de santé.
- Éviter de considérer les choix alimentaires comme de simples « erreurs » : chercher les **contraintes** (budget, temps, équipement, offre).
- Privilégier les actions qui agissent sur l'**environnement** (offre de la cantine, épicerie solidaire, tarification sociale) en plus de l'éducation.
- Adapter les messages et les supports à la **littératie** du public.
- Mesurer, dans l'évaluation, si l'action profite aussi aux plus défavorisés (indicateur de participation par quartier ou par situation sociale).

À vous de jouer – Exercice d'application 2.2

Une campagne d'affichage « Mangez 5 fruits et légumes par jour » est diffusée dans toute une ville. Six mois plus tard, la consommation a augmenté de 10 % chez les cadres et de 2 % chez les ouvriers. a) L'action a-t-elle réduit les inégalités ? b) Expliquez ce résultat. c) Proposez deux actions complémentaires.

Corrigé

a) Non : l'écart entre cadres et ouvriers s'est **creusé** (+ 10 % contre + 2 %), même si tous les groupes ont progressé : c'est l'effet « Matthieu » des actions d'information universelles. **b)** Les cadres disposent de plus de

ressources pour suivre le message : revenus, temps, accès aux commerces, littératie, croyance en leur capacité à changer. Chez les ouvriers, les **contraintes** (prix, offre, horaires) limitent l'effet du seul message. **c)** Actions complémentaires (universalisme proportionné) : distribution de fruits à prix réduits ou de chèques « fruits et légumes » dans les quartiers prioritaires ; ateliers cuisine petit budget avec les centres sociaux ; amélioration de l'offre de fruits dans la restauration collective et au travail ; adaptation des supports (pictogrammes, recettes à moins de 1 €).

Effet de composition et effet de contexte

Quand un territoire a une moins bonne santé que la moyenne, deux explications se combinent.

Définition – Effet de composition et effet de contexte

- **Effet de composition** : le territoire **regroupe** des personnes qui ont, quel que soit l'endroit où elles vivent, une santé moins bonne (personnes âgées, ouvriers, personnes sans diplôme, personnes à faibles revenus). Si l'on corrige ces différences de population (standardisation sur l'âge, comparaison à catégorie sociale égale), l'écart diminue.
- **Effet de contexte** : le territoire **lui-même** agit sur la santé de ses habitants, à caractéristiques individuelles égales : offre alimentaire, transports, logements dégradés, espaces verts, offre de soins, pollution, réputation du quartier, vie associative.

Exemple – Lire un écart territorial

Dans un quartier prioritaire fictif, 21 % des adultes sont obèses, contre 15 % dans la commune. Après prise en compte de l'âge, du diplôme et du revenu des habitants, l'écart n'est plus que de 2 points. **Lecture** : l'essentiel de l'écart (4 points sur 6) s'explique par la composition sociale du quartier (effet de composition) ; les 2 points restants peuvent traduire un effet du contexte (offre alimentaire, sécurité des espaces publics pour marcher). **Conséquence** : il faut agir à la fois sur les conditions de vie des habitants (revenus, accès aux aides) et sur l'environnement du quartier (commerces, jardins, parcours de marche).

Les territoires où les difficultés se cumulent

Type de territoire	Ce qui se cumule	Exemples de leviers en nutrition
Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)	Revenus faibles (le critère qui définit un QPV est le faible revenu des habitants), familles monoparentales, chômage, offre alimentaire peu diversifiée	Contrat de ville et atelier santé ville, épiceries solidaires, ateliers au centre social, cantine à tarif social
Territoires ruraux isolés	Distance aux commerces et aux soins, vieillissement, isolement, dépendance à la voiture	Portage de repas, épiceries itinérantes, transport à la demande, vente directe des producteurs, projet alimentaire territorial
Départements et régions d'outre-mer	Mortalité standardisée plus élevée (en 2023, 89 % au-dessus de la moyenne nationale à Mayotte et 37 % en Guyane, Inserm-CépiDc, 2025), obésité et diabète plus fréquents, prix alimentaires élevés	Loi Lurel (2013) sur la teneur en sucres des produits vendus outre-mer, programmes régionaux, valorisation des produits locaux

Attention – Ne pas stigmatiser un territoire

Présenter un quartier uniquement par ses manques renforce sa mauvaise image et décourage ses habitants. Un diagnostic présente aussi les **ressources** du territoire : associations, marchés, jardins, savoir-faire culinaires des habitants, centres sociaux. Écrivez « le quartier compte 36 % de ménages pauvres » plutôt que

« un quartier pauvre », et « des habitants qui ont peu accès aux produits frais » plutôt que « des habitants qui mangent mal ».

À vous de jouer – Exercice d'application 2.2 bis

Dans une commune rurale, la part de personnes de 75 ans ou plus dénutries repérées par le portage de repas est de 14 %, contre 9 % dans le département. Les personnes de la commune sont plus âgées en moyenne et le dernier commerce a fermé. a) Identifiez un effet de composition et un effet de contexte possibles. b) Proposez une analyse qui permettrait de séparer les deux. c) Proposez un levier pour chacun.

Corrigé

a) Composition : la commune compte davantage de personnes très âgées (85 ans ou plus), plus souvent dénutries, quel que soit le lieu. Contexte : la fermeture du dernier commerce et l'absence de transport rendent l'accès aux aliments difficile pour tous les habitants âgés. **b)** Comparer la dénutrition **à âge égal** (par tranche d'âge, ou avec un taux standardisé sur l'âge) ; s'il reste un écart, il peut traduire l'effet du contexte. **c)** Composition : repérage systématique de la dénutrition chez les 85 ans ou plus (pesée lors du portage, grille HAS). Contexte : épicerie itinérante ou transport à la demande vers le marché, repas partagés au village.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 2.3.2 – Les inégalités sociales et territoriales de santé

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez les trois caractéristiques des inégalités sociales de santé.
2. Définissez le gradient social de santé.
3. Citez l'écart d'espérance de vie entre les 5 % les plus modestes et les 5 % les plus aisés, chez les hommes et chez les femmes, avec la source.
4. Calcul : 31 % des enfants d'un quartier prioritaire et 12 % des enfants d'un quartier favorisé boivent un soda par jour. Calculez l'écart absolu et l'écart relatif.
5. Distinguez effet de composition et effet de contexte.
6. Calculez le nombre d'unités de consommation d'un couple avec un enfant de 10 ans.

Corrigé – Point d'étape 2.3.2

1. Systématiques, socialement produites (donc évitables), injustes.
2. L'état de santé s'améliore à chaque échelon de l'échelle sociale, pas seulement entre les plus pauvres et les autres.
3. Environ 13 ans chez les hommes (71,7 contre 84,4 ans) et 8 ans chez les femmes (80,0 contre 88,3 ans) ; Insee, 2018, données 2012-2016.
4. Écart absolu : 31 − 12 = 19 points. Écart relatif : 31 / 12 = 2,58.
5. Composition : le territoire regroupe des personnes dont la santé est moins bonne partout (âge, revenu). Contexte : le territoire lui-même agit sur la santé (offre alimentaire, transports, logement).
6. 1 + 0,5 + 0,3 = 1,8 UC.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

2.3.3 Mesurer l'état de santé : les indicateurs démographiques

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §5 (p. 5) ; Essentiels M1 S1 §5 (p. 6) ; Essentiels M1 S1 §5 (p. 7)

Un **indicateur** est une variable mesurable qui résume une information complexe et permet de comparer des populations dans l'espace et dans le temps. Pour être utile, il doit être **défini** (formule), **daté**, **sourcé** et rapporté à une **population de référence**.

À retenir – Trois mots à ne pas confondre

- **Effectif** (ou nombre) : 342 décès.
- **Proportion** : partie d'un tout, sans unité, entre 0 et 1 (ou 0 et 100 %) : 32 % de moins de 18 ans.
- **Taux** : nombre d'événements survenus **pendant une période** rapporté à la population exposée pendant cette période, souvent exprimé pour 1 000 (‰) ou pour 100 000 habitants : 9,0 décès pour 1 000 habitants en 2026.

La population et sa structure

- **Population** : nombre d'habitants à une date (au 1er janvier 2026, la France compte **69,1 millions** d'habitants ; Insee, Bilan démographique 2025).
- **Structure par âge** : proportions de moins de 20 ans (22,5 %), de 65 ans ou plus (**22,2 %**) et de 75 ans ou plus (11,1 %) au 1er janvier 2026. Pour la première fois, les 65 ans ou plus sont presque aussi nombreux que les moins de 20 ans.
- **Rapport de dépendance** = (moins de 20 ans + 65 ans ou plus) / (20 à 64 ans) × 100 : il mesure le nombre de personnes « dépendantes » pour 100 personnes d'âge actif.
- **Indice de vieillissement** = 65 ans ou plus / moins de 20 ans × 100.

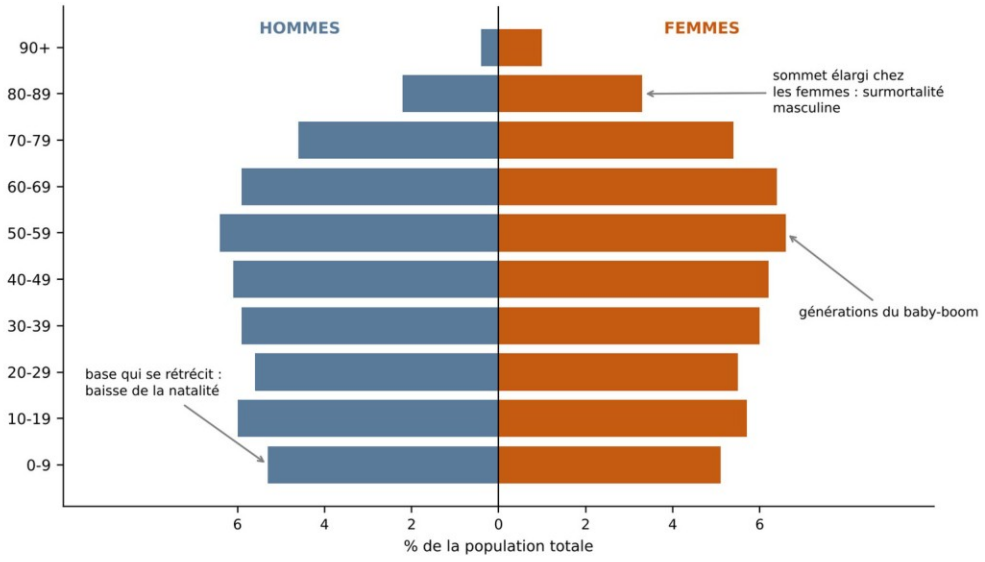


Figure 2.5 – Une pyramide des âges (population fictive d'une commune, en % de la population totale)

Comprendre le schéma – Figure 2.5

1. L'axe vertical représente les **groupes d'âge** (de 10 ans) ; à gauche les **hommes**, à droite les **femmes**, en pourcentage de la population totale.
2. La **base qui se rétrécit** traduit une baisse de la natalité (moins d'enfants que de jeunes adultes).
3. Le **renflement** entre 50 et 69 ans correspond aux générations nombreuses du baby-boom (nées entre 1946 et 1975 environ).
4. Le **sommet plus large côté femmes** traduit la surmortalité masculine : les femmes vivent plus longtemps.
5. Lecture pour le diététicien : une pyramide « vieillissante » oriente vers la prévention de la **dénutrition** et le « bien vieillir » ; une base large oriente vers la petite enfance (« 1000 premiers jours ») et les écoles.

Reconnaître les grandes formes de pyramide

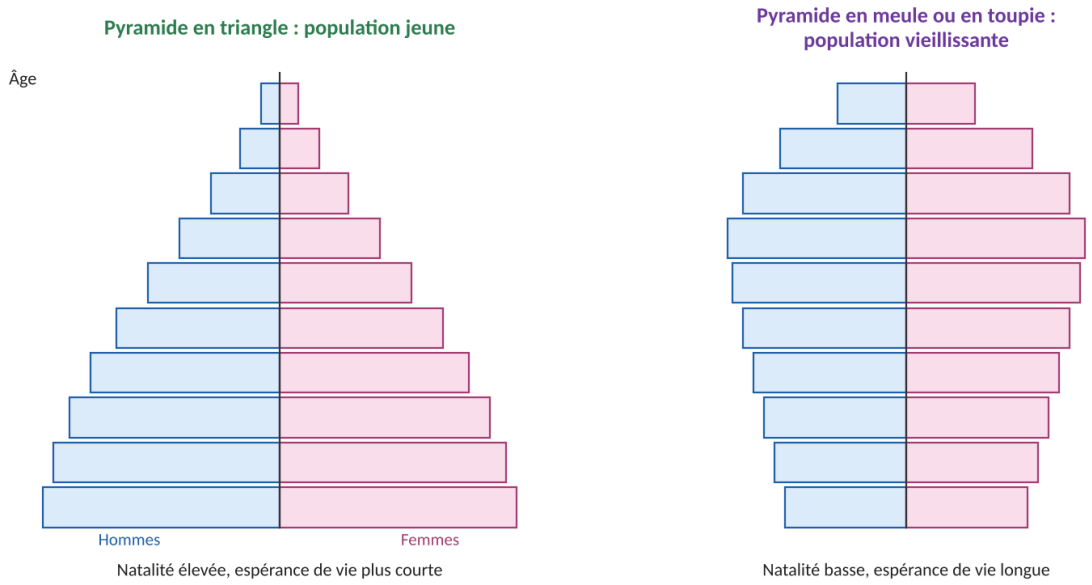


Figure 2.5 bis – Pyramide « jeune » et pyramide « vieillissante »

Comprendre le schéma – Figure 2.5 bis

1. À gauche, une **pyramide en triangle** : base large, sommet étroit. La natalité est élevée et l'espérance de vie plus courte ; la population est jeune.
2. À droite, une **pyramide en meule (ou en toupie)** : base étroite, renflement aux âges adultes et âgés. La natalité est basse et l'espérance de vie longue ; la population vieillit.
3. Entre les deux, une **pyramide en cloche** (non représentée) correspond à une natalité stable et à une population qui se renouvelle juste.
4. La France est proche de la meule : base qui se rétrécit (645 000 naissances en 2025, Insee) et générations nombreuses du baby-boom désormais âgées de 50 à 80 ans environ.

Méthode pas à pas – Commenter une pyramide des âges en 5 étapes

1. Présenter : territoire, date, source, unité (effectifs ou pourcentages).

2. Décrire la forme générale : triangle, cloche, meule ; population jeune ou vieillissante.

3. Repérer les anomalies : creux (classes creuses : guerres, baisse de natalité), renflements (baby-boom, arrivée d'étudiants ou de jeunes actifs), déséquilibre entre hommes et femmes (surmortalité masculine aux âges élevés, migrations de travail).

4. Chiffrer : part des moins de 20 ans, part des 65 ans ou plus, indice de vieillissement.

5. Conclure pour l'action : quel public prioritaire, quels besoins nutritionnels (petite enfance, adolescents, personnes âgées), quelles évolutions dans 10 ans.

Exemple – Pyramide d'une ville universitaire

Une ville moyenne qui accueille une université présente un fort renflement entre 18 et 25 ans, des deux côtés de la pyramide, et une base étroite. **Lecture** : ce renflement ne vient pas de la natalité mais de l'**arrivée d'étudiants**, qui repartent après leurs études. **Conséquence pour le diététicien** : les besoins portent sur l'alimentation des étudiants (précarité alimentaire, repas sautés, cuisine en kitchenette), en lien avec le

CROUS et les épiceries solidaires étudiantes ; la natalité basse ne signifie pas que la population est âgée.

Natalité et fécondité

- **Taux brut de natalité** = nombre de naissances vivantes de l'année / population moyenne de l'année × 1 000.
- **Indicateur conjoncturel de fécondité (ICF)** : nombre moyen d'enfants qu'aurait une femme tout au long de sa vie si les taux de fécondité par âge de l'année restaient inchangés. En 2025, il est de **1,56 enfant par femme**, le niveau le plus bas depuis la fin de la Première Guerre mondiale ; 645 000 bébés sont nés (Insee, 2026). Le seuil de remplacement des générations est d'environ 2,1.
- **Solde naturel** = naissances − décès : en 2025, il est **négatif** (− 6 000), pour la première fois depuis 1945 (Insee).

Exemple – Calculer un taux de natalité

Données : commune de 38 000 habitants (population moyenne de l'année) ; 418 naissances vivantes. **Formule** : taux brut de natalité = naissances / population moyenne × 1 000. **Application** : 418 / 38 000 × 1 000 = **11,0 naissances pour 1 000 habitants** (11,0 ‰). **Interprétation** : ce taux est supérieur à celui de la France (645 000 naissances pour 69 millions d'habitants, soit environ 9,3 ‰) : la commune est relativement jeune ; les actions destinées aux familles et à la petite enfance y sont pertinentes.

Trois autres indicateurs à connaître

Indicateur	Définition exacte	Calcul
Taux de nuptialité	Nombre de mariages de l'année rapporté à la population moyenne	mariages / population moyenne × 1 000 (‰)
Taux (général) de fécondité	Naissances vivantes de l'année rapportées au nombre de femmes de 15 à 49 ans	naissances / femmes de 15 à 49 ans × 1 000 (‰)
Indice de développement humain (IDH)	Indice du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) qui combine la santé (espérance de vie à la naissance), l'éducation (durée moyenne et durée attendue de scolarisation) et le niveau de vie (revenu national brut par habitant)	moyenne géométrique des trois indices ; valeur entre 0 et 1

Attention – Ne pas confondre taux de fécondité et ICF

Le **taux de fécondité** est un rapport « naissances / femmes de 15 à 49 ans » pour une année. L'**indicateur conjoncturel de fécondité** (1,56 enfant par femme en France en 2025) est un nombre moyen d'enfants par femme : il additionne les taux de fécondité de chaque âge. Depuis 2010, l'IDH ne se calcule plus avec le taux d'alphabétisation et le PIB, mais avec les durées de scolarisation et le revenu national brut par habitant.

Calcul – Taux de nuptialité et taux de fécondité d'une commune (données fictives)

Données : 24 500 habitants (population moyenne), dont 5 120 femmes de 15 à 49 ans ; 196 naissances vivantes et 98 mariages dans l'année.

Taux de nuptialité : 98 / 24 500 × 1 000 = **4,0 ‰**.

Taux de fécondité : 196 / 5 120 × 1 000 ≈ **38,3 ‰**, soit 38,3 naissances pour 1 000 femmes de 15 à 49 ans.

Espérance de vie et espérance de vie sans incapacité

Définition – Espérance de vie à la naissance

Nombre moyen d'années que vivrait une génération fictive soumise toute sa vie aux **taux de mortalité par âge de l'année considérée**. C'est un indicateur « du moment », indépendant de la structure par âge de la population : il permet de comparer des pays ou des périodes. En 2025, elle est de **85,9 ans pour les femmes** et de **80,3 ans pour les hommes** (Insee) ; l'écart entre les sexes s'est réduit à 5,6 ans (7,1 ans en 2005).

Définition – Espérance de vie sans incapacité (EVSI)

Nombre moyen d'années qu'une personne peut espérer vivre **sans être limitée** dans les activités de la vie quotidienne (limitation déclarée depuis au moins 6 mois). Indicateur européen « années de vie en bonne santé ». En 2024, l'EVSI **à 65 ans** est de **11,8 ans pour les femmes** et de **10,5 ans pour les hommes** (Drees, *Études et résultats* n° 1363, janvier 2026). Elle complète l'espérance de vie : vivre plus longtemps n'a de sens que si ces années sont vécues en bonne santé, ce qui donne toute son importance à la prévention nutritionnelle (dénutrition, sarcopénie, maladies chroniques).

Attention – Erreurs fréquentes sur l'espérance de vie

- Ce n'est **pas** l'âge moyen au décès (celui-ci dépend de la structure par âge).
- Ce n'est **pas** une prévision pour les bébés nés cette année : c'est une photographie des conditions de mortalité **de l'année**.
- Une espérance de vie de 80 ans ne signifie pas que la plupart des personnes meurent à 80 ans.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 2.3.3 – Les indicateurs démographiques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Distinguez une proportion et un taux.
2. Calcul : une ville de 48 000 habitants (population moyenne) compte 612 naissances et 380 décès dans l'année. Calculez le taux de natalité, le taux de mortalité et le solde naturel.
3. Donnez la formule de l'indice de vieillissement et du rapport de dépendance.
4. Donnez l'indicateur conjoncturel de fécondité et le solde naturel de la France en 2025.
5. Vrai ou faux : « L'espérance de vie est l'âge moyen au décès. » Justifiez.
6. Que signifie une pyramide dont la base se rétrécit ?

Corrigé – Point d'étape 2.3.3

1. Une proportion est une partie d'un tout (sans durée) ; un taux rapporte des événements survenus pendant une période à la population exposée pendant cette période.
2. Natalité : 612 / 48 000 × 1 000 = 12,75 ‰. Mortalité : 380 / 48 000 × 1 000 = 7,92 ‰. Solde naturel : 612 − 380 = + 232.
3. Indice de vieillissement = 65 ans ou plus / moins de 20 ans × 100. Rapport de dépendance = (moins de 20 ans + 65 ans ou plus) / 20-64 ans × 100.
4. 1,56 enfant par femme ; solde naturel négatif (environ − 6 000), une première depuis 1945 (Insee, 2026).
5. Faux : c'est le nombre moyen d'années que vivrait une génération fictive soumise aux taux de mortalité par âge de l'année ; l'âge moyen au décès dépend de la structure par âge.
6. Une baisse de la natalité : il naît moins d'enfants que dans les générations précédentes.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

2.3.4 Les indicateurs de mortalité et de morbidité

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §5 (p. 6) ; Essentiels M1 S1 §5 (p. 7)

Les taux de mortalité

Indicateur	Formule	Exemple
Taux brut de mortalité	Décès de l'année / population moyenne × 1 000	342 / 38 000 × 1 000 = 9,0 ‰
Taux spécifique (par âge, par sexe, par cause)	Décès dans le sous-groupe / population du sous-groupe × 1 000 (ou × 100 000)	Décès des 65 ans ou plus / population des 65 ans ou plus
Taux de mortalité par cause	Décès dus à la cause / population × 100 000	En 2024, les tumeurs ont causé 173 502 décès, soit environ 253 pour 100 000 habitants (Drees, Inserm-CépiDc, Santé publique France, juin 2026)
Taux de mortalité infantile	Décès d'enfants de moins d'un an / naissances vivantes × 1 000	Ordre de grandeur en France : environ 4 ‰
Mortalité prématurée	Décès avant 65 ans (taux ou part)	Indicateur de la qualité de la prévention
Mortalité évitable	Décès avant 75 ans qui auraient pu être évités par la prévention (« évitable par la prévention ») ou par les soins (« traitable »)	Cancers du poumon, accidents, maladies liées à l'alcool, une partie des maladies cardiovasculaires

Pourquoi standardiser ? La standardisation directe

Le taux brut de mortalité dépend fortement de l'**âge** de la population : une commune âgée a mécaniquement plus de décès. Pour comparer deux populations, on calcule un **taux standardisé** (ou « comparatif ») : on applique les taux spécifiques par âge de chaque population à une **même population de référence** (population type).

Méthode pas à pas – Calculer un taux standardisé par la méthode directe

Données : deux communes de 10 000 habitants.

Âge	Pop. A	Décès A	Taux A (‰)	Pop. B	Décès B	Taux B (‰)
0-39 ans	4 000	4	1,0	6 000	9	1,5
40-64 ans	3 500	21	6,0	3 000	24	8,0
65 ans ou plus	2 500	125	50,0	1 000	60	60,0
Total	10 000	150	15,0	10 000	93	9,3

Étape 1 – Taux bruts : A = 150 / 10 000 × 1 000 = **15,0 ‰** ; B = 93 / 10 000 × 1 000 = **9,3 ‰**. La commune A semble avoir une mortalité plus élevée. **Étape 2 – Taux spécifiques** : taux = décès du groupe / population du groupe × 1 000 (voir le tableau). Dans **chaque** groupe d'âge, B a une mortalité plus élevée que A. **Étape 3 – Choisir une population de référence** : 5 000 (0-39 ans), 3 200 (40-64 ans), 1 800 (65 ans ou plus), soit 10 000 personnes. **Étape 4 – Décès attendus dans la population de référence** : A = 5 000 × 1,0/1 000 + 3 200 × 6,0/1 000 + 1 800 × 50,0/1 000 = 5 + 19,2 + 90 = **114,2** ; B = 5 000 × 1,5/1 000 + 3 200 × 8,0/1 000 + 1 800 × 60,0/1 000 = 7,5 + 25,6 + 108 = **141,1**. **Étape 5 – Taux standardisés** : A = 114,2 / 10 000 × 1 000 = **11,4 ‰** ; B = 141,1 /

10 000 × 1 000 = **14,1 ‰**. **Interprétation** : à structure d'âge identique, la mortalité de B est **supérieure** à celle de A (14,1 ‰ contre 11,4 ‰), alors que son taux brut était plus faible. Le taux brut de A était élevé parce que sa population est **âgée** (25 % de 65 ans ou plus contre 10 %). Conclusion : on ne compare jamais deux territoires avec des taux bruts.

La standardisation indirecte et le rapport standardisé de mortalité

Dans un petit territoire (quartier, petite commune), les décès par âge sont trop peu nombreux pour calculer des taux spécifiques fiables. On utilise alors la **méthode indirecte** : on applique les taux spécifiques d'une **population de référence** (département, région, France) à la **population du territoire**, ce qui donne le nombre de décès **attendus**. On compare ensuite les décès **observés** aux décès attendus.

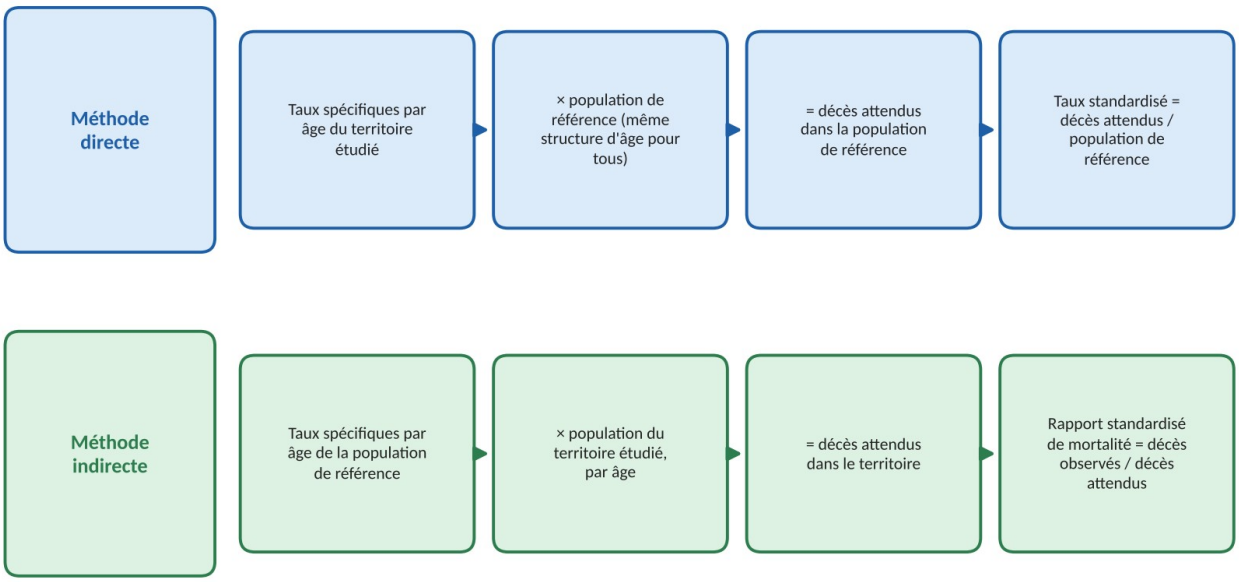


Figure 2.5 ter – Méthode directe et méthode indirecte

Comprendre le schéma – Figure 2.5 ter

1. **Méthode directe** (ligne du haut) : on part des taux spécifiques du territoire étudié, on les applique à une population de référence commune, on obtient des décès attendus dans cette population, puis un **taux standardisé**. Elle demande des effectifs suffisants dans chaque groupe d'âge.
2. **Méthode indirecte** (ligne du bas) : on part des taux spécifiques de la référence, on les applique à la population du territoire, on obtient des décès attendus dans le territoire, puis le **rapport standardisé de mortalité** (RSM) = décès observés / décès attendus.
3. Le RSM multiplié par 100 donne l'**indice comparatif de mortalité** (ICM), utilisé par les ORS : 100 = même mortalité que la référence ; 120 = 20 % de décès en plus ; 85 = 15 % de décès en moins.

Méthode pas à pas – Calculer un rapport standardisé de mortalité

Données (fictives, moyenne annuelle sur 3 ans) : commune de 6 000 habitants ; 63 décès observés par an.

Âge	Population de la commune	Taux de référence (‰)	Décès attendus
Moins de 65 ans	4 800	1,8	4 800 × 1,8 / 1 000 = 8,64
65 à 84 ans	1 000	22,0	1 000 × 22,0 / 1 000 = 22,00
85 ans ou plus	200	130,0	200 × 130,0 / 1 000 = 26,00
Total	6 000		56,64

Étape 1 – Décès attendus : 8,64 + 22,00 + 26,00 = **56,64**. **Étape 2 – RSM** = 63 / 56,64 = **1,112** ; ICM = **111,2**. **Étape 3 – Interpréter** : à structure d'âge égale, la commune a environ 11 % de décès en plus que la référence. **Étape 4 – Vérifier la précision** : pour un petit nombre de décès D, un intervalle de confiance approché à 95 % est D ± 1,96 × √D, soit 63 ± 1,96 × √63 = 63 ± 15,6, c'est-à-dire de 47,4 à 78,6 décès. Le RSM est donc compris entre 47,4 / 56,64 = **0,84** et 78,6 / 56,64 = **1,39**. L'intervalle contient 1 : la surmortalité **n'est pas démontrée** ; il faut regrouper plus d'années ou s'appuyer sur d'autres indicateurs.

Attention – Deux erreurs fréquentes avec le RSM

- On ne compare pas les RSM de deux communes entre eux : chacun compare une commune à **la référence**, avec sa propre structure d'âge.
- Un RSM supérieur à 1 n'est pas forcément significatif : regardez toujours le nombre de décès et l'intervalle de confiance (les ORS signalent les écarts significatifs par une couleur ou un astérisque dans leurs tableaux).

À vous de jouer – Exercice d'application 2.2 ter

Un quartier compte 3 000 personnes de moins de 65 ans et 600 personnes de 65 ans ou plus. Les taux de la région sont de 2,0 ‰ avant 65 ans et de 40,0 ‰ à 65 ans ou plus. On observe 45 décès par an. Calculez les décès attendus, le RSM et l'ICM ; interprétez.

Corrigé

Décès attendus = 3 000 × 2,0 / 1 000 + 600 × 40,0 / 1 000 = 6 + 24 = **30**. RSM = 45 / 30 = **1,50** ; ICM = **150**. Le quartier a 50 % de décès en plus que si sa population avait la mortalité par âge de la région. Intervalle approché : 45 ± 1,96 × √45 = 45 ± 13,1, soit 31,9 à 58,1 décès, donc un RSM de 1,06 à 1,94 : l'intervalle ne contient pas 1, la surmortalité est significative. Elle justifie un diagnostic des causes (maladies cardio-vasculaires, cancers, conduites à risque) et des actions de prévention.

Les causes de décès

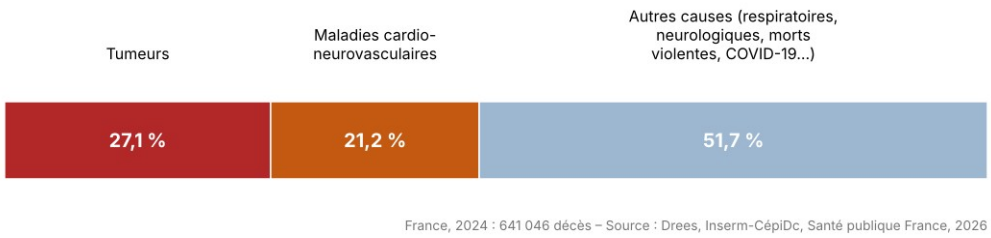


Figure 2.6 – Répartition des décès selon la cause en France en 2024

Comprendre le schéma – Figure 2.6

1. En 2024, **641 046 décès** ont été enregistrés en France ; le taux standardisé de mortalité a encore baissé, à 777,9 décès pour 100 000 habitants (Drees, Inserm-CépiDc, Santé publique France, juin 2026).
2. Les **tumeurs** sont la première cause de décès (**27,1 %**).
3. Les **maladies cardio-neurovasculaires** sont la deuxième (**21,2 %**).
4. Les autres causes regroupent notamment les maladies respiratoires, neurologiques, les morts violentes (accidents, suicides) et la COVID-19, en net recul.

5. Lecture nutritionnelle : l'alimentation et l'activité physique sont des facteurs de risque ou de protection majeurs des deux premières causes ; une partie de ces décès relève de la **mortalité évitable par la prévention**.

Mortalité prématurée, mortalité évitable et années potentielles de vie perdues

Les décès des personnes très âgées pèsent lourd dans le nombre total de décès, mais ils sont en grande partie inévitables. Pour orienter la **prévention**, on s'intéresse aux décès **précoces**.

Définition – Mortalité prématurée et mortalité évitable

- **Mortalité prématurée** : décès survenus **avant 65 ans**. La France a une mortalité prématurée élevée par rapport à ses voisins européens, surtout chez les hommes, alors que sa mortalité aux grands âges est faible.
- **Mortalité évitable** (définition OCDE et Eurostat, décès **avant 75 ans**) : elle se partage en mortalité **évitable par la prévention** (décès qui auraient pu être évités par des actions sur les comportements et l'environnement : cancers du poumon, maladies liées à l'alcool, accidents, une partie des maladies cardio-vasculaires et du diabète) et mortalité **traitable** (décès qui auraient pu être évités par des soins adaptés et précoces).

Définition – Années potentielles de vie perdues (APVP)

Somme, pour tous les décès survenus avant un âge limite (souvent 75 ans), du nombre d'années qui séparent l'âge au décès de cet âge limite. Un décès à 40 ans « coûte » 35 années potentielles ; un décès à 72 ans en coûte 3. L'indicateur donne plus de poids aux décès des jeunes.

Calcul détaillé – Calculer des APVP avant 75 ans (données fictives, une année)

Âge au décès	Nombre de décès	Âge moyen retenu	Années perdues par décès	APVP
0 à 24 ans	2	12,5	75 − 12,5 = 62,5	2 × 62,5 = 125
25 à 44 ans	6	35	75 − 35 = 40	6 × 40 = 240
45 à 64 ans	24	55	75 − 55 = 20	24 × 20 = 480
65 à 74 ans	30	70	75 − 70 = 5	30 × 5 = 150
Total	62			995

Lecture : les 62 décès avant 75 ans représentent **995 années potentielles de vie perdues**, soit 995 / 62 = **16,0 années** en moyenne par décès. Les décès de 45 à 64 ans pèsent **48,2 %** des APVP (480 / 995), alors qu'ils ne représentent que 24 décès sur 62. C'est à ces âges que la prévention des maladies cardio-vasculaires, du diabète, des cancers liés à l'alcool et à l'alimentation a le plus d'effet.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.2 quater

Dans un territoire, on compte en un an 4 décès entre 25 et 44 ans (âge moyen 35 ans) et 40 décès entre 65 et 74 ans (âge moyen 70 ans). a) Calculez les APVP de chaque groupe et le total. b) Quel groupe pèse le plus en nombre de décès, et lequel en APVP ? c) Concluez.

Corrigé

a) 25-44 ans : 4 × (75 − 35) = 4 × 40 = **160** ; 65-74 ans : 40 × (75 − 70) = 40 × 5 = **200** ; total **360** APVP. **b)** Les 65-74 ans pèsent le plus en nombre (40 décès contre 4), mais seulement 200 / 360 = **55,6 %** des APVP ; les 4

décès de 25 à 44 ans représentent **44,4 %** des APVP. **c)** Un petit nombre de décès de jeunes adultes représente presque autant d'années de vie perdues que dix fois plus de décès à 65-74 ans : les APVP font apparaître l'enjeu des décès précoces (accidents, suicides, alcool, maladies cardio-vasculaires précoces).

Les indicateurs de morbidité

Indicateur	Définition	Source
Prévalence	Nombre (ou proportion) de cas existants à un moment donné / population au même moment	Enquêtes (ESTEBAN, Baromètre), registres
Incidence	Nombre de nouveaux cas survenus pendant une période / population à risque au début de la période	Registres (cancers), cohortes
Affections de longue durée (ALD)	Personnes prises en charge à 100 % pour une maladie chronique (diabète, cancers, maladies cardiovasculaires)	Assurance maladie (SNDS)
Hospitalisations	Séjours hospitaliers par diagnostic	PMSI (ATIH)
Recours aux soins	Consultations, médicaments remboursés (par exemple, personnes traitées pour un diabète)	SNDS, Cartosanté
Santé perçue	Part des personnes jugeant leur santé « bonne » ou « très bonne »	Enquêtes (EHIS, Baromètre)
Années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI, en anglais DALY)	Années de vie perdues par décès prématuré + années vécues avec une incapacité	OMS, Global Burden of Disease

À retenir – Prévalence = incidence × durée (en situation stable)

Une maladie fréquente peut être **peu incidente mais longue** (diabète de type 2 : on vit longtemps avec) ou **très incidente mais courte** (gastro-entérite). La prévention **primaire** réduit l'incidence ; la prévention **secondaire** réduit la durée, donc la prévalence.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.3

Dans une commune de 12 000 habitants, 1 080 personnes sont traitées pour un diabète au 1er janvier. Pendant l'année, 96 personnes non diabétiques au 1er janvier (sur 10 920) commencent un traitement. Calculez la prévalence au 1er janvier et l'incidence cumulée annuelle.

Corrigé

Prévalence = cas existants / population = 1 080 / 12 000 = 0,09, soit **9,0 %**. **Incidence cumulée** = nouveaux cas / population à risque au début = 96 / 10 920 = 0,00879, soit **0,88 %** (8,8 pour 1 000 personnes à risque par an). **Interprétation** : la population à risque exclut les personnes déjà malades (12 000 − 1 080 = 10 920). Une prévalence de 9 % est nettement supérieure à la moyenne nationale (environ 5 à 6 % de la population traitée pour un diabète) : il faudrait vérifier la structure par âge de la commune (population âgée ?) avant de conclure, d'où l'intérêt des taux standardisés.

Incidence cumulée et taux d'incidence

Dans une cohorte réelle, les personnes ne sont pas toutes suivies pendant la même durée : certaines entrent en cours d'étude, d'autres déménagent ou décèdent. On rapporte alors les nouveaux cas au **temps total d'observation**.

Définition – Deux façons d'exprimer l'incidence

- **Incidence cumulée** (ou risque) : nouveaux cas pendant la période / personnes à risque au début de la période. Elle s'exprime en pourcentage sur une durée précisée (« 0,88 % en un an »).
- **Taux d'incidence** (ou densité d'incidence) : nouveaux cas / somme des durées d'observation de chaque personne, en **personnes-années**. Il s'exprime par exemple « pour 1 000 personnes-années ».

Calcul détaillé – Taux d'incidence du diabète dans une cohorte (données fictives)

Une maison de santé suit 1 200 adultes non diabétiques pendant au plus 5 ans ; certains ont déménagé en cours de suivi. La somme des durées de suivi est de **5 480 personnes-années**. On observe **46** nouveaux diabètes.

- Taux d'incidence = 46 / 5 480 × 1 000 = **8,39 pour 1 000 personnes-années**.
- Si l'on avait divisé par les 1 200 personnes du départ, on aurait obtenu 46 / 1 200 × 100 = 3,83 % « en 5 ans », en supposant à tort que tous avaient été suivis 5 ans.

Lecture : environ 8 nouveaux diabètes par an pour 1 000 adultes suivis. Le taux d'incidence est la mesure correcte quand les durées de suivi diffèrent.

À retenir – Quelle mesure pour quelle question ?

Question	Mesure	Exemple
Combien de personnes ont le problème aujourd'hui ?	Prévalence	Dimensionner un service : nombre de places en éducation thérapeutique
Combien de personnes le développent chaque année ?	Incidence	Évaluer la prévention primaire : baisse des nouveaux cas
Combien en meurent ?	Mortalité	Mesurer la gravité et le poids de la maladie
Quelle proportion des malades en meurt ?	Létalité = décès parmi les malades / malades	Gravité d'une maladie aiguë (toxi-infection alimentaire collective)

À vous de jouer – Exercice d'application 2.3 bis

Lors d'une toxi-infection alimentaire collective dans un centre de vacances, 180 personnes ont consommé le repas, 54 sont tombées malades et 1 personne âgée est décédée. Calculez le taux d'attaque (incidence pendant l'épisode) et la létalité ; expliquez la différence entre létalité et mortalité.

Corrigé

Taux d'attaque = 54 / 180 × 100 = **30,0 %** des convives. Létalité = 1 / 54 × 100 = **1,9 %** des malades. La **létalité** rapporte les décès aux **malades** : elle mesure la gravité de la maladie. La **mortalité** rapporte les décès à **toute la population** (ici 1 / 180 = 0,6 %) : elle mesure le poids de la maladie dans la population.

Mesurer la santé perçue et les limitations d'activité

Les indicateurs de mortalité et de morbidité ne disent pas comment les personnes **vivent** leur santé. Les enquêtes européennes utilisent un **mini-module** de trois questions, repris dans les enquêtes françaises (EHIS, enquêtes de la Drees, Baromètre de Santé publique France).

Document – Le mini-module européen sur la santé

1. Santé perçue : « Comment est votre état de santé en général ? » (très bon, bon, assez bon, mauvais, très mauvais).

2. Maladie chronique : « Avez-vous une maladie ou un problème de santé qui soit chronique ou de caractère durable ? »
3. Limitation d'activité (indicateur GALI) : « Êtes-vous limité(e), depuis au moins six mois, à cause d'un problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement ? »

La troisième question sert à calculer l'**espérance de vie sans incapacité**.

Calcul détaillé – Limitations d'activité chez les 65 ans ou plus d'une commune (enquête fictive)

Sur 1 200 personnes de 65 ans ou plus interrogées au hasard, 456 déclarent être limitées depuis au moins six mois. Prévalence = 456 / 1 200 × 100 = **38,0 %** ; marge d'erreur = 1,96 × √(0,38 × 0,62 / 1 200) = **2,7 points**, soit un intervalle de 35,3 % à 40,7 %. **Lecture** : plus d'une personne âgée sur trois est limitée dans ses activités ; ce sont des personnes pour qui faire les courses, cuisiner ou se déplacer au marché peut être difficile. Le diagnostic oriente vers des actions qui **s'adaptent aux limitations** (portage, livraison, repas partagés accessibles, ustensiles adaptés).

Attention – Une donnée subjective, mais solide

La santé perçue est **déclarée** : elle dépend de la culture, de l'âge et des attentes de chacun. Elle est pourtant un **bon prédicteur de la mortalité**, indépendamment des maladies diagnostiquées. Elle suit un gradient social net, ce qui en fait un bon indicateur d'inégalités.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 2.3.4 – Mortalité, morbidité et standardisation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi ne compare-t-on jamais deux territoires avec des taux bruts de mortalité ?
2. Calcul : 18 décès sont survenus chez les 2 400 personnes de 65 à 74 ans d'une commune. Calculez le taux spécifique.
3. Calcul : 6 décès avant 1 an pour 1 500 naissances vivantes. Calculez le taux de mortalité infantile.
4. Quelle méthode de standardisation utiliser pour un quartier de 3 000 habitants ? Pourquoi ?
5. Distinguez prévalence et incidence.
6. Quelle est la première cause de décès en France en 2024 et quelle part des décès représente-t-elle ?

Corrigé – Point d'étape 2.3.4

1. Le taux brut dépend de la structure par âge : un territoire âgé a mécaniquement plus de décès. Il faut des taux standardisés.
2. 18 / 2 400 × 1 000 = 7,50 ‰.
3. 6 / 1 500 × 1 000 = 4,00 ‰.
4. La méthode indirecte (RSM), car les décès par âge sont trop peu nombreux pour des taux spécifiques fiables.
5. Prévalence : cas existants à un moment donné / population. Incidence : nouveaux cas pendant une période / population à risque au début.
6. Les tumeurs, 27,1 % des décès (Drees, Inserm-CépiDc, 2026).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

2.3.5 Les sources de données et le portrait de santé d'un territoire

Module · Référentiel : C3.1, C3.4 · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §5 (p. 5)

Source	Ce qu'on y trouve	Accès
Insee	Population, structure par âge, naissances, décès, revenus, pauvreté (Filosofi), diplômes, emploi, à l'échelle de la commune et du QPV	insee.fr (statistiques locales)
Drees	État de santé de la population, espérance de vie sans incapacité, enquêtes de santé scolaire, établissements, professionnels	drees.solidarites-sante.gouv.fr ; data.drees
Inserm-CépiDc	Causes médicales de décès	cepidc.inserm.fr
Santé publique France	Surveillance, Baromètre, ESTEBAN, indicateurs régionaux et départementaux (Géodes)	santepubliquefrance.fr ; geodes.santepubliquefrance.fr
Assurance maladie	ALD, consommations de soins, pathologies traitées (Data pathologies)	data.ameli.fr
ORS et FNORS	Diagnostics locaux, indicateurs comparatifs (Score-santé), portraits de territoire	sites des ORS ; scoresante.org
ARS	Diagnostic du PRS, diagnostics des contrats locaux de santé	sites des ARS
Politique de la ville (ANCT)	Données sur les QPV, cartographie	sig.ville.gouv.fr ; observatoire des territoires

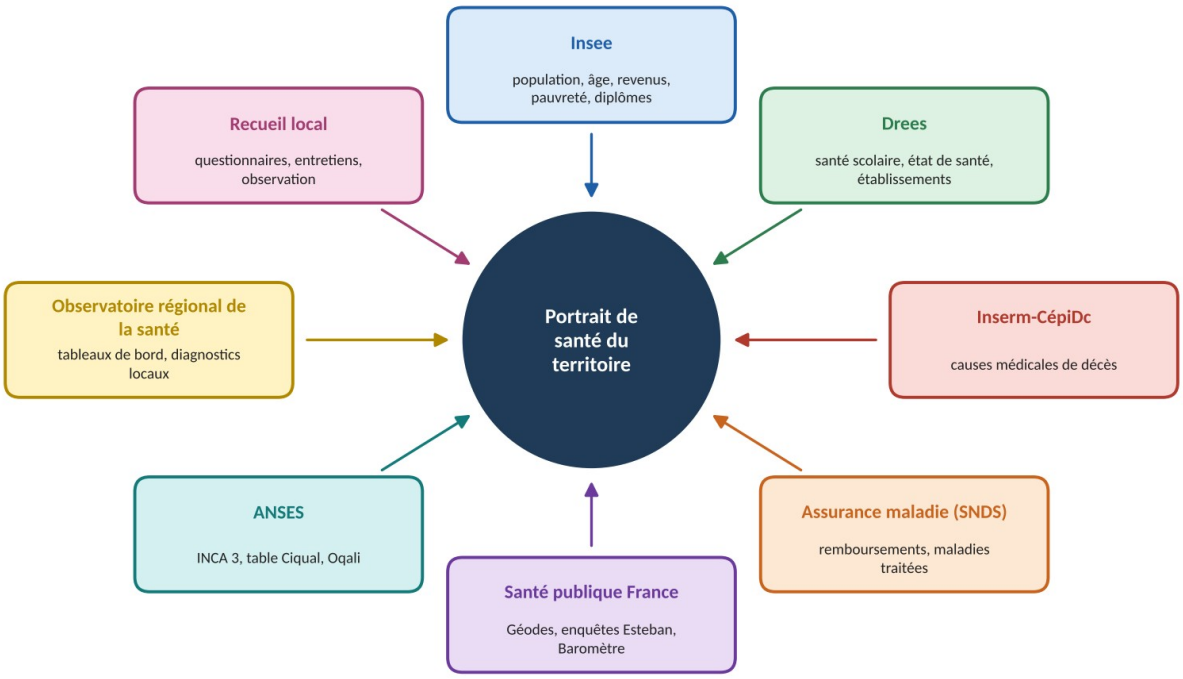


Figure 2.6 bis – Les sources d'un portrait de santé de territoire

Comprendre le schéma – Figure 2.6 bis

1. Au centre, le **portrait de santé du territoire**, qui rassemble toutes les données.
2. **Insee** : population, âges, revenus, pauvreté, diplômes. **Drees** : santé scolaire, état de santé, établissements.
3. **Inserm-CépiDc** : causes médicales de décès. **Assurance maladie (SNDS)** : remboursements, maladies traitées, ALD.
4. **Santé publique France** : Géodes, enquêtes Esteban, Baromètre. **ANSES** : INCA 3, table Ciqual, Oqali.
5. **Observatoire régional de la santé** : tableaux de bord et diagnostics locaux, souvent la source la plus rapide pour un territoire.
6. **Recueil local** : questionnaires, entretiens, observation ; c'est la seule source qui renseigne les besoins ressentis et exprimés du public.

Les qualités d'un bon indicateur

Un indicateur n'est utile que s'il mesure bien ce qu'on veut savoir, et s'il est disponible au bon moment et au bon endroit.

Qualité	Question à se poser	Exemple
Validité	Mesure-t-il vraiment le phénomène ?	Le nombre de personnes traitées pour un diabète sous-estime le diabète (diabètes non diagnostiqués)
Fiabilité	Donne-t-il le même résultat si on refait la mesure ?	Une pesée sur une balance non étalonnée n'est pas fiable
Sensibilité au changement	Bouge-t-il si la situation change ?	La mortalité bouge trop lentement pour évaluer un projet d'un an ; la consommation déclarée de légumes bouge plus vite
Spécificité	Mesure-t-il ce phénomène et pas un autre ?	La fréquentation d'un atelier mesure l'intérêt, pas le changement de comportement
Disponibilité et coût	Peut-on l'obtenir facilement, à l'échelle voulue ?	Esteban n'existe qu'à l'échelle nationale ; le taux de pauvreté existe par commune (Insee)
Comparabilité	Peut-on le comparer à une référence et dans le temps ?	Utiliser la même question avant et après un atelier ; utiliser des taux standardisés

Attention – Secret statistique et confidentialité

Les données de santé sont des données sensibles (RGPD). Les organismes masquent les **petits effectifs** pour éviter qu'on reconnaisse une personne (secret statistique). Dans un diagnostic de stage, on présente des données **agrégées**, on ne cite jamais un nom ni un cas identifiable (« la seule famille du hameau qui… »), et on demande l'accord de la structure avant de diffuser des données internes.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.3 ter

Pour évaluer un projet d'un an d'ateliers cuisine dans un centre social, une stagiaire propose trois indicateurs : a) la mortalité cardio-vasculaire de la commune ; b) la part des participants qui déclarent cuisiner des légumes au moins 3 fois par semaine, avec la même question avant et après ; c) le nombre de participants à chaque atelier. Discutez la pertinence de chacun.

Corrigé

a) Non pertinent : la mortalité de toute la commune ne dépend pas d'ateliers suivis par quelques dizaines de

personnes et ne bouge pas en un an (indicateur peu **sensible** et peu **spécifique**). **b)** Pertinent : indicateur de **résultat**, sensible au changement, comparable grâce à la même question ; limite, c'est une donnée déclarée. **c)** Utile comme indicateur de **processus** (participation, assiduité), mais il ne mesure pas le changement de comportement.

Méthode pas à pas – Construire un portrait de santé de territoire en 6 étapes

1. Délimiter le territoire (commune, quartier, intercommunalité) et la population cible.

2. Démographie : population, structure par âge, évolution, ménages, familles monoparentales (Insee).

3. Situation sociale : revenus, taux de pauvreté, chômage, diplômes, QPV (Insee, politique de la ville).

4. État de santé : espérance de vie, mortalité standardisée, mortalité prématurée, ALD, données de santé scolaire ou de PMI (ORS, Géodes, Assurance maladie).

5. Déterminants et ressources : offre alimentaire, restauration collective, équipements sportifs, offre de soins, associations (observation, Cartosanté, entretiens).

6. Comparer chaque indicateur à une référence (département, région, France), **dater** et **sourcer**, puis rédiger 3 à 5 constats.

Lien diététique – Fiche-outil

Le portrait de territoire se réalise avec l'outil **O1.2** (chapitre 1) et alimente la fiche **F1 – Diagnostic de situation**. Les calculs de taux se font dans la feuille 4 du tableur **BC3_Calculateur_projet.xlsx**.

Lire un tableau d'indicateurs de l'ORS

Les ORS publient des tableaux comparant un territoire à sa région et à la France, souvent sous forme d'**indices comparatifs** (base 100) avec un signe de **significativité**.

Exemple – Un tableau type (valeurs fictives, présentation inspirée des tableaux de bord des ORS)

Indicateur (période)	Territoire	Région	France	Écart significatif ?
Indice comparatif de mortalité générale (2019-2023)	108	102	100	Oui, au-dessus
Indice comparatif de mortalité prématurée (2019-2023)	121	105	100	Oui, au-dessus
Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (2019-2023)	103	99	100	Non
Part de la population couverte par la complémentaire santé solidaire (2024)	13,8 %	10,1 %	11,0 %	–
Diabète traité, taux standardisé (2023)	6,4 %	5,7 %	5,6 %	Oui, au-dessus

Lecture : la mortalité prématurée est l'écart le plus marqué (21 % au-dessus de la France, significatif) ; la mortalité par maladies circulatoires n'est pas significativement différente, malgré un indice de 103 : on ne la commente pas comme une surmortalité. Le diabète traité est plus fréquent, à âge égal, et la précarité (complémentaire santé solidaire) est plus élevée. **Constat pour le diagnostic** : « Le territoire présente une surmortalité prématurée significative (indice 121, ORS, 2019-2023) et une fréquence plus élevée du diabète traité, dans un contexte de précarité plus marquée qu'en région. »

2.3.6 Les indicateurs de l'état nutritionnel d'une population

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Synthèse M3 S1 §1 (p. 26)

POUR MIEUX COMPRENDRE – niveau BTS (exigible) En santé publique, l'état nutritionnel se mesure à l'échelle d'un **groupe** : on ne pose pas de diagnostic individuel, on estime des **prévalences** à partir de mesures standardisées. Le diététicien doit connaître ces indicateurs pour lire les études (ESTEBAN, Albane) et pour construire un recueil de données en stage.

Dimension	Indicateur et seuils	Source de référence
Corpulence de l'adulte	IMC = poids (kg) / taille² (m²) : maigreur < 18,5 ; normal 18,5-24,9 ; surpoids 25-29,9 ; obésité ≥ 30 (classe I 30-34,9 ; II 35-39,9 ; III ≥ 40)	OMS
Adiposité abdominale	Tour de taille : risque accru si ≥ 94 cm (homme) ou ≥ 80 cm (femme), risque élevé si ≥ 102 cm ou ≥ 88 cm	OMS / IDF
Corpulence de l'enfant	IMC rapporté à l'âge et au sexe : courbes de référence françaises (carnet de santé 2018) ; seuils IOTF-25 (surpoids) et IOTF-30 (obésité)	Références françaises, IOTF
Consommations alimentaires	Proportion de personnes atteignant un repère (5 fruits et légumes, légumes secs 2 fois/semaine, fibres ≥ 25 g/jour…)	INCA, ESTEBAN, Albane, Baromètre
Activité physique et sédentarité	Proportion atteignant 30 min/jour (adulte) ou 60 min/jour (enfant) ; temps assis	Baromètre de Santé publique France
Insécurité alimentaire	Échelle FIES (8 questions, FAO) ou échelle HFSSM (18 questions) ; question simple « avoir assez à manger » (Crédoc)	FAO, Crédoc
Dénutrition	Critères HAS (2019 adulte, 2021 personne de 70 ans et plus) : au moins un critère phénotypique (perte de poids, IMC bas, sarcopénie) et un critère étiologique	HAS
Statut biologique	Ferritine (fer), 25-OH vitamine D, folates… dans des enquêtes avec prélèvements	ESTEBAN, Albane

Exemple – Calculer une prévalence de surpoids à partir de mesures

Données : dans une enquête de quartier, 250 adultes ont été pesés et mesurés : 68 ont un IMC entre 25 et 29,9 ; 45 ont un IMC ≥ 30. **Étape 1 – Prévalence de l'obésité** = 45 / 250 = 0,18, soit **18,0 %**. **Étape 2 – Prévalence du surpoids hors obésité** = 68 / 250 = **27,2 %**. **Étape 3 – Surpoids obésité comprise** = (68 + 45) / 250 = 113 / 250 = **45,2 %**. **Interprétation** : ces valeurs sont proches des données nationales mesurées (ESTEBAN 2015 : 49 % de surpoids dont 17 % d'obésité chez les 18-74 ans) ; avec 250 personnes, la précision reste limitée (intervalle de confiance, chapitre 16) et l'échantillon doit être représentatif du quartier.

Attention – Mesuré ou déclaré ?

Le poids déclaré est en moyenne **sous-estimé** et la taille **surestimée** : les prévalences issues de données déclaratives (Baromètre, OFÉO) sont plus basses que celles issues de mesures (ESTEBAN). Précisez toujours la méthode.

Échantillon, marge d'erreur et taille d'échantillon

Dans un projet de terrain, on interroge rarement toute la population : on interroge un **échantillon**. Le résultat obtenu est une **estimation** qui comporte une marge d'erreur liée au hasard.

Définition – Marge d'erreur et intervalle de confiance d'une proportion

Pour une proportion p observée sur n personnes tirées au hasard, la **marge d'erreur** à 95 % vaut **1,96 × √(p × (1 − p) / n)**. L'**intervalle de confiance à 95 %** va de p moins la marge à p plus la marge : si l'on répétait l'enquête de nombreuses fois, 95 % des intervalles ainsi calculés contiendraient la vraie valeur. La formule suppose un échantillon tiré au hasard et un effectif suffisant (n × p et n × (1 − p) au moins égaux à 5).

Calcul détaillé – Combien de personnes interroger ?

On veut estimer la part d'adultes d'une commune qui consomment des légumes secs au moins deux fois par semaine, avec une marge d'erreur de 5 points. On prévoit une proportion d'environ 30 %.

- Formule de la taille d'échantillon : **$n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$**, avec e la marge voulue.
- $n = 1{,}96^2 \times 0{,}30 \times 0{,}70 / 0{,}05^2 = 3{,}8416 \times 0{,}21 / 0{,}0025 =$ **322,7**, soit **323 personnes**.
- Si l'on ne connaît pas p, on prend p = 0,5 (cas le plus défavorable) : n = 3,8416 × 0,25 / 0,0025 = 384,2, soit **385 personnes**.
- Pour une marge de 3 points avec p = 0,30 : n = 3,8416 × 0,21 / 0,0009 = 896,4, soit **897 personnes**.

Lecture : diviser la marge par deux demande environ quatre fois plus de personnes. En stage, on ne peut souvent interroger que 40 à 100 personnes : on présente alors les résultats comme des **tendances**, avec leur marge, et on les croise avec d'autres sources.

Attention – Le hasard n'est pas la seule erreur

La marge d'erreur ne corrige que le hasard. Elle ne corrige pas les **biais** : un questionnaire distribué seulement aux personnes qui viennent déjà au centre social (biais de sélection), une question qui oriente la réponse, une donnée déclarée sous-estimée (biais d'information). Un grand échantillon biaisé donne un résultat précis… et faux.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.3 quater

Sur 600 adultes interrogés au hasard dans une commune, 84 déclarent avoir sauté au moins un repas par manque d'argent dans le mois. a) Calculez la proportion et sa marge d'erreur à 95 %. b) Donnez l'intervalle de confiance. c) Quel serait l'effet d'avoir interrogé seulement les personnes présentes à la distribution alimentaire ?

Corrigé

a) p = 84 / 600 = **14,0 %** ; marge = 1,96 × √(0,14 × 0,86 / 600) = 1,96 × 0,01417 = **0,028**, soit **2,8 points**. **b)** De 14,0 − 2,8 = **11,2 %** à 14,0 + 2,8 = **16,8 %**. **c)** Un **biais de sélection** : les personnes présentes à une distribution alimentaire sont plus souvent en difficulté ; la proportion serait fortement surestimée et ne représenterait pas la commune.

Mesurer l'adéquation aux repères alimentaires

Pour décrire l'alimentation d'un public, on calcule la **part des personnes qui atteignent chaque repère** du PNNS plutôt qu'une moyenne de consommation, plus difficile à interpréter.

Calcul détaillé – Atteinte des repères dans un questionnaire de fréquence (données fictives, 150 adultes)

Repère (PNNS)	Personnes qui l'atteignent	Part
Au moins 5 portions de fruits et légumes par jour	42	42 / 150 × 100 = 28,0 %
Légumes secs au moins 2 fois par semaine	27	27 / 150 × 100 = 18,0 %

Repère (PNNS)	Personnes qui l'atteignent	Part
Féculents complets au moins 1 fois par jour	33	33 / 150 × 100 = 22,0 %
Boissons sucrées : pas plus d'un verre par jour	118	118 / 150 × 100 = 78,7 %

Lecture : les légumes secs et les féculents complets sont les repères les moins suivis ; ce sont des cibles prioritaires d'un atelier, d'autant qu'ils sont peu coûteux. Le repère sur les boissons sucrées est atteint par près de 4 adultes sur 5. **Limite** : données déclarées par un questionnaire de fréquence, qui surestime souvent les aliments « bien vus » (fruits et légumes).

À retenir – Les méthodes de recueil des consommations

Méthode	Principe	Avantages	Limites
Rappel des 24 heures	Décrire tout ce qui a été mangé la veille, avec un enquêteur	Précis, peu d'oublis guidés	Un seul jour n'est pas représentatif ; il en faut plusieurs
Carnet ou enregistrement alimentaire	Noter ou photographier tout ce qui est consommé pendant 3 à 7 jours	Détaillé, quantités	Lourd ; les personnes modifient leur alimentation pendant le recueil
Questionnaire de fréquence	« Combien de fois par semaine mangez-vous… ? »	Rapide, adapté aux grands groupes et au suivi d'une action	Quantités approximatives ; surestimation des aliments valorisés
Histoire alimentaire	Entretien sur les habitudes sur une longue période	Vision globale, utile en consultation	Dépend de la mémoire et de l'enquêteur

À vous de jouer – Exercice d'application 2.3 quinquies

Vous devez évaluer l'effet d'ateliers « légumes secs » sur 40 participants en 3 mois. Quelle méthode de recueil choisissez-vous ? Rédigez la question et l'indicateur.

Corrigé

Un **questionnaire de fréquence court**, posé avant et 3 mois après, avec exactement la même question : « Au cours des 7 derniers jours, combien de fois avez-vous mangé des légumes secs (lentilles, pois chiches, haricots secs…) ? » Indicateur : part des participants qui en consomment au moins 2 fois par semaine, avant et après. Avec 40 personnes, on présente le résultat en effectifs (« 9 sur 40 avant, 21 sur 40 après ») et comme une tendance.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 2.3.5 et 2.3.6 – Sources de données et état nutritionnel

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez la source de chacune de ces données : taux de pauvreté d'une commune ; causes de décès ; pathologies traitées par commune ; composition des aliments.
2. Calculez l'IMC d'un adulte de 95 kg et 1,70 m et classez-le.
3. Donnez les seuils de tour de taille à risque élevé chez l'homme et chez la femme.
4. Pourquoi les prévalences d'obésité issues de données déclarées sont-elles plus basses ?
5. Citez trois qualités d'un bon indicateur.
6. Quelles sont les six étapes d'un portrait de santé de territoire ?

Corrigé – Point d'étape 2.3.5 et 2.3.6

1. Insee (Filosofi) ; Inserm-CépiDc ; Assurance maladie (data.ameli.fr) ; ANSES, table Ciqual.
2. 95 / 1,70² = 95 / 2,89 = 32,9 : obésité de classe I (30 à 34,9).
3. 102 cm chez l'homme, 88 cm chez la femme (risque accru dès 94 cm et 80 cm).
4. Les personnes sous-estiment leur poids et surestiment leur taille.
5. Validité, fiabilité, sensibilité au changement (aussi : spécificité, disponibilité, comparabilité).
6. Délimiter le territoire ; démographie ; situation sociale ; état de santé ; déterminants et ressources ; comparer, dater, sourcer et rédiger des constats.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

2.3.7 Les transitions démographique, épidémiologique et nutritionnelle

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : pas de passage correspondant (voir 2.2.2)

La transition démographique

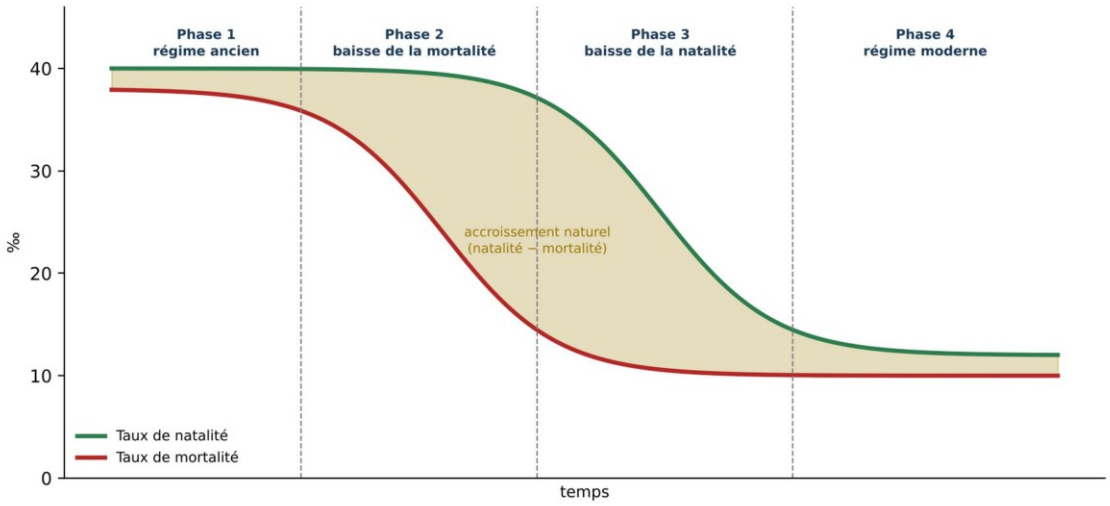


Figure 2.9 – Le modèle de la transition démographique

Comprendre le schéma – Figure 2.9

1. Phase 1 – Régime ancien : natalité et mortalité sont toutes deux élevées (de l'ordre de 35 à 40 ‰) ; la population augmente très lentement ; l'espérance de vie est faible (famines, épidémies, mortalité infantile).

2. Phase 2 – Baisse de la mortalité : grâce à l'amélioration de l'alimentation, de l'hygiène, de la médecine (vaccination, eau potable), la mortalité diminue alors que la natalité reste forte : l'**accroissement naturel** (natalité − mortalité) est maximal, la population augmente rapidement (en France, à partir de la fin du XVIIIe siècle).

3. Phase 3 – Baisse de la natalité : la fécondité diminue (scolarisation, urbanisation, contraception, travail des femmes) ; l'accroissement naturel se réduit.

4. Phase 4 – Régime moderne : natalité et mortalité sont basses (autour de 10 ‰) ; la population se stabilise et **vieillit**.

5. La France, comme les autres pays à revenu élevé, est en phase 4 : la natalité y a atteint son niveau le plus

bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale (environ 645 000 naissances en 2025, après 663 000 en 2024, selon les bilans démographiques de l'Insee) et le nombre de décès rejoint désormais celui des naissances : l'accroissement naturel est devenu nul ou négatif ; la croissance de la population repose sur le solde migratoire. Vérifiez le dernier bilan démographique de l'Insee (publié chaque mois de janvier).

Mesurer le vieillissement

Indicateur	Formule	Interprétation
Part des 65 ans ou plus	population de 65 ans ou plus / population totale × 100	Environ 21 à 22 % en France en 2024- 2025 (Insee)
Indice de vieillissement	population de 65 ans ou plus / population de moins de 20 ans × 100	Nombre de seniors pour 100 jeunes ; > 100 : plus de seniors que de jeunes
Rapport de dépendance démographique	(moins de 20 ans + 65 ans ou plus) / 20-64 ans × 100	Nombre de personnes « dépendantes » (jeunes et âgés) pour 100 personnes en âge de travailler
Rapport de dépendance des âgés	65 ans ou plus / 20-64 ans × 100	Charge des retraités sur les actifs potentiels

Exemple – Calcul détaillé : vieillissement de deux territoires

Commune rurale A : 18 000 habitants ; moins de 20 ans : 3 420 ; 20-64 ans : 9 360 ; 65 ans ou plus : 5 220.
Quartier urbain B : 4 200 habitants ; moins de 20 ans : 1 260 ; 20-64 ans : 2 520 ; 65 ans ou plus : 420.

- Vérification des totaux : A : 3 420 + 9 360 + 5 220 = **18 000** ; B : 1 260 + 2 520 + 420 = **4 200** . ✓ ✓
- Part des 65 ans ou plus : A : 5 220 / 18 000 × 100 = **29,0 %** ; B : 420 / 4 200 × 100 = **10,0 %**.
- Indice de vieillissement : A : 5 220 / 3 420 × 100 = **152,6** (153 seniors pour 100 jeunes) ; B : 420 / 1 260 × 100 = **33,3**.
- Rapport de dépendance : A : (3 420 + 5 220) / 9 360 × 100 = 8 640 / 9 360 × 100 = **92,3** ; B : (1 260 + 420) / 2 520 × 100 = 1 680 / 2 520 × 100 = **66,7**.

Interprétation : la commune A, très âgée, appelle des actions de prévention de la **dénutrition** et de la perte d'autonomie (portage de repas, repas partagés, financements de la conférence des financeurs) ; le quartier B, jeune, oriente vers les **enfants et les familles** (1000 premiers jours, restauration scolaire, ateliers parents-enfants). Le diagnostic démographique **oriente le choix du public prioritaire**.

La transition épidémiologique

Avec la transition démographique, les **causes de maladie et de décès** changent : les maladies **infectieuses** et les **carences** reculent, les maladies **chroniques non transmissibles** (cancers, maladies cardio-neurovasculaires, diabète, maladies respiratoires chroniques, maladies neurodégénératives) deviennent prédominantes. C'est la **transition épidémiologique** (Omran, 1971). Les maladies chroniques sont responsables d'environ **74 % des décès** dans le monde (OMS, 2023) et sont fortement liées à des **facteurs modifiables** : tabac, alcool, alimentation, sédentarité, pollution.

Les âges de la transition épidémiologique

Âge (Omran, 1971, complété par Olshansky et Ault, 1986)	Causes de décès dominantes	Espérance de vie
1. Âge des pestilences et des famines	Maladies infectieuses, famines, mortalité infantile très élevée	Faible (souvent moins de 30 à 40 ans)
2. Âge du recul des pandémies	Les épidémies reculent grâce à l'alimentation, l'hygiène, l'eau potable	Augmente nettement

Âge (Omran, 1971, complété par Olshansky et Ault, 1986)	Causes de décès dominantes	Espérance de vie
3. Âge des maladies dégénératives et « de société »	Maladies cardio-vasculaires, cancers, liés à l'alimentation, au tabac, à la sédentarité	Élevée
4. Âge des maladies dégénératives retardées	Les mêmes maladies surviennent plus tard grâce à la prévention et aux soins	Continue d'augmenter aux grands âges

À retenir – Ce que la transition change pour la nutrition

Aux deux premiers âges, la nutrition de santé publique lutte contre les **carences** et la **faim**. Aux âges 3 et 4, elle lutte surtout contre les **excès** et les **déséquilibres** (sel, sucres, graisses saturées, manque de fibres) et contre la **dénutrition des personnes âgées**, plus nombreuses. La France est au quatrième âge ; certains territoires et groupes cumulent encore des carences (fer, vitamine D) : c'est le double fardeau.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.3 sexies

Associez chaque situation à un âge de la transition épidémiologique : a) la baisse de la mortalité par tuberculose en Europe au XIXe siècle ; b) la hausse des maladies cardio-vasculaires après 1950 ; c) le recul de l'âge moyen au premier infarctus grâce au dépistage et à la prévention ; d) les famines de l'Ancien Régime.

Corrigé

a) Âge 2, recul des pandémies (alimentation, conditions de vie, hygiène). b) Âge 3, maladies dégénératives et de société. c) Âge 4, maladies dégénératives retardées : la maladie survient plus tard. d) Âge 1, pestilences et famines.

La transition nutritionnelle

Définition – Transition nutritionnelle (Popkin, 1993)

Évolution des régimes alimentaires qui accompagne le développement économique et l'urbanisation : on passe d'une alimentation riche en **céréales peu raffinées, légumineuses et légumes**, pauvre en produits animaux, à une alimentation plus riche en **produits animaux, sucres ajoutés, graisses, aliments transformés**, avec une baisse de l'activité physique. Elle s'accompagne d'une hausse du **surpoids**, de l'**obésité** et des maladies chroniques.

Stade (Popkin)	Alimentation	Conséquences
1. Cueillette	Variée, riche en fibres, pauvre en graisses	Population mince, active ; espérance de vie faible
2. Famines	Agriculture ; alimentation monotone ; pénuries	Carences, retards de croissance
3. Recul des famines	Plus de fruits, légumes, protéines animales	Baisse des carences ; amélioration de la croissance
4. Maladies chroniques liées à l'alimentation	Graisses, sucres, aliments transformés ; sédentarité	Obésité, diabète, maladies cardiovasculaires
5. Changement de comportement	Retour vers plus de végétal, politiques nutritionnelles	Réduction des maladies chroniques (objectif)

Attention – Le « double fardeau » de la malnutrition

Dans de nombreux pays, et même au sein d'un même foyer, coexistent **dénutrition** (ou carences en micronutriments) et **surpoids**. En France, on observe à la fois l'obésité et la dénutrition des personnes âgées ou malades, et des carences ciblées (fer chez les adolescentes, vitamine D). Le terme « malnutrition » désigne **toutes** ces situations, et pas seulement la dénutrition.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.4

Dans un département, la part des 65 ans ou plus est passée de 18,0 % à 23,5 % en 20 ans. a) Calculez la hausse en points et la variation relative. b) Quelles conséquences pour la politique nutritionnelle locale ?

Corrigé

a) Hausse : 23,5 − 18,0 = **5,5 points** ; variation relative : 5,5 / 18,0 × 100 = **+ 30,6 %. b)** Prévention de la dénutrition (repérage, portage de repas enrichis, repas partagés), qualité de la restauration en EHPAD et à domicile (BC2), activité physique adaptée, actions de la conférence des financeurs, formation des aides à domicile.

2.3.8 Le fardeau des maladies chroniques liées à la nutrition en France

Module · Référentiel et guide : voir 2.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 2.2.2)

Les grandes pathologies

Pathologie	Données-clés	Source
Surpoids et obésité (adultes)	49 % des adultes de 18 à 74 ans en surpoids, dont 17 % en obésité (mesures 2015)	Santé publique France, Esteban
Surpoids et obésité (enfants)	17 % des 6-17 ans en surpoids, dont 4 % en obésité (2015) ; forte dépendance au milieu social	Santé publique France, Esteban
Diabète	Plus de 5 % de la population traitée pharmacologiquement (plus de 3,8 millions de personnes en 2023, soit 5,6 %), à 90 % de type 2 ; prévalence plus élevée dans les territoires défavorisés et en outre-mer	Santé publique France
Maladies cardio- neurovasculaires	Deuxième cause de décès (environ 140 000 décès par an) ; facteurs nutritionnels : sel (hypertension), acides gras saturés, fibres insuffisantes, obésité	Santé publique France, CépiDc
Cancers	Environ 433 000 nouveaux cas en 2023 ; 41 % des cancers attribuables à des facteurs modifiables, dont alcool 8 %, alimentation 5,4 %, surpoids et obésité 5,4 %, activité physique insuffisante 0,9 % (estimations 2015)	INCa ; CIRC (2018)
Dénutrition	Environ 2 millions de personnes concernées, dont une part importante de personnes âgées (10 % à domicile, 15 à 40 % en EHPAD, 30 à 50 % à l'hôpital selon les sources)	HAS (2019, 2021) ; collectif de lutte contre la dénutrition

Attention – Attention à la date et à la méthode

Les données d'**Esteban** (2014-2016) sont les dernières données **mesurées** de corpulence en population générale ; les enquêtes **déclaratives** (poids et taille déclarés) sous-estiment le surpoids. Les études plus

récentes (cohortes, enquêtes déclaratives) montrent une poursuite de la hausse de l'obésité adulte, notamment chez les jeunes adultes : vérifiez toujours la **méthode** et l'**année** avant de citer un chiffre.

Mesurer le fardeau : les AVCI

Méthode pas à pas – Calculer des années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI)

AVCI = années de vie perdues (AVP) + années vécues avec incapacité (AVI)

- **AVP** = nombre de décès × années de vie perdues en moyenne par décès (espérance de vie à l'âge du décès).
- **AVI** = nombre de cas × poids d'incapacité (de 0 = pleine santé à 1 = décès) × durée moyenne.

Une AVCI représente **une année de vie en bonne santé perdue**.

Exemple – Calcul détaillé : AVCI liées au diabète dans un territoire (données fictives, une année)

- Décès attribués au diabète : **12**, survenus en moyenne **15 ans** avant l'espérance de vie : AVP = 12 × 15 = **180**.
- Personnes diabétiques sans complication : **2 400**, poids d'incapacité **0,05**, sur 1 an : AVI = 2 400 × 0,05 × 1 = **120**.
- Personnes diabétiques avec complications (neuropathie, rétinopathie) : **300**, poids **0,20**, sur 1 an : AVI = 300 × 0,20 × 1 = **60**.
- **AVCI** = 180 + 120 + 60 = **360 années de vie en bonne santé perdues** sur l'année.

Lecture : la moitié du fardeau (180 / 360 = **50 %**) vient de l'incapacité, et non des décès : un indicateur fondé sur la seule mortalité sous-estimerait l'enjeu ; prévenir les complications (éducation, alimentation, activité physique) a donc un intérêt majeur.

Trois indicateurs synthétiques à ne pas confondre

Indicateur	Ce qu'il additionne ou combine	Usage
Espérance de vie sans incapacité (EVSI)	Années vécues sans limitation d'activité, à partir des taux de mortalité et d'une enquête sur les limitations	Comparer la santé des pays et des groupes sociaux ; indicateur européen « années de vie en bonne santé »
AVCI (DALY)	Années de vie perdues par décès prématuré + années vécues avec une incapacité, pondérées par sa gravité	Mesurer le **fardeau** d'une maladie ou d'un facteur de risque (Global Burden of Disease) ; fixer des priorités
QALY (années de vie ajustées sur la qualité)	Années de vie multipliées par un coefficient de qualité de vie, de 0 (décès) à 1 (pleine santé)	Évaluation **médico-économique** : comparer le coût d'une intervention aux QALY gagnés (HAS)

Calcul détaillé – Un ratio coût-efficacité en QALY (données fictives)

Un programme d'éducation thérapeutique pour 50 personnes diabétiques coûte 100 000 €. On estime qu'il améliore la qualité de vie des participants de 0,70 à 0,80 pendant 10 ans.

- Gain par personne = (0,80 − 0,70) × 10 = **1,0 QALY**.
- Gain total = 50 × 1,0 = **50 QALY**.
- Coût par QALY gagné = 100 000 / 50 = **2 000 € par QALY**.

Lecture : plus le coût par QALY est faible, plus l'intervention est efficiente. Les actions de prévention nutritionnelle collectives (réduction du sel dans les produits, restauration scolaire) ont souvent un coût par

QALY très faible, car elles touchent beaucoup de personnes pour un coût unitaire bas.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.4 bis

Une maladie A cause 50 décès par an (20 années perdues en moyenne) et 400 cas vivent avec un poids d'incapacité de 0,1 pendant l'année. Une maladie B cause 10 décès (10 années perdues en moyenne) et 3 000 cas vivent avec un poids d'incapacité de 0,2. a) Calculez les AVCI de chaque maladie. b) Laquelle pèse le plus ? c) Laquelle serait prioritaire si l'on ne regardait que la mortalité ?

Corrigé

a) A : AVP = 50 × 20 = 1 000 ; AVI = 400 × 0,1 = 40 ; AVCI = **1 040**. B : AVP = 10 × 10 = 100 ; AVI = 3 000 × 0,2 = 600 ; AVCI = **700**. **b)** La maladie A pèse le plus (1 040 contre 700 AVCI). **c)** Avec la seule mortalité, A serait aussi prioritaire (50 décès contre 10), mais l'écart paraîtrait bien plus grand (5 fois plus de décès, seulement 1,5 fois plus d'AVCI) : B, très invalidante, serait sous-estimée. Les AVCI rendent visibles les maladies chroniques qui tuent peu mais pèsent sur la vie quotidienne (arthrose, dépression, obésité).

Lien diététique – Le fardeau mondial des risques alimentaires

L'étude *Global Burden of Disease* (GBD 2017, publiée dans le *Lancet* en 2019) estime que les **risques alimentaires** (trop de sel, pas assez de céréales complètes, de fruits, de légumes, de fruits à coque…) étaient responsables d'environ **11 millions de décès** et de **255 millions d'AVCI** dans le monde en 2017, soit davantage que le tabac. Le premier facteur était l'excès de **sodium**, suivi du manque de **céréales complètes** et de **fruits**. Ce constat fonde la priorité donnée à la nutrition dans les politiques de santé.

Les indicateurs de la dénutrition chez la personne âgée

La dénutrition n'apparaît pas dans les grandes enquêtes de corpulence, où l'on parle surtout de surpoids. Pourtant, elle concerne une part importante des personnes âgées (environ 10 % à domicile, 15 à 40 % en EHPAD, 30 à 50 % à l'hôpital selon les sources ; HAS, 2019 et 2021). Pour un diagnostic de territoire ou d'établissement, il faut connaître ses critères.

À retenir – Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans ou plus (HAS et FFN, 2021)

Le diagnostic repose sur **au moins un critère phénotypique** et **au moins un critère étiologique**.

- **Critères phénotypiques** : perte de poids d'au moins 5 % en 1 mois ou d'au moins 10 % en 6 mois ou d'au moins 10 % par rapport au poids habituel avant le début de la maladie ; IMC inférieur à 22 ; sarcopénie confirmée.
- **Critères étiologiques** : réduction de la prise alimentaire d'au moins 50 % pendant plus d'une semaine, ou toute réduction pendant plus de deux semaines par rapport à la consommation habituelle ou aux besoins ; absorption réduite ; situation d'agression (maladie aiguë, inflammation chronique, cancer).
- **Dénutrition sévère** : au moins un critère parmi IMC inférieur à 20, perte de poids d'au moins 10 % en 1 mois ou d'au moins 15 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel, albuminémie inférieure ou égale à 30 g/L.

Calcul détaillé – Repérage dans un EHPAD (données fictives)

Une résidente pesait 64 kg avant une hospitalisation (poids habituel), 62 kg il y a 6 mois et 57 kg aujourd'hui ; elle mange moins de la moitié de ses repas depuis 10 jours. Perte sur 6 mois : (62 − 57) / 62 × 100 = **8,1 %** (moins de 10 %). Perte par rapport au poids habituel : (64 − 57) / 64 × 100 = **10,9 %** (au moins 10 %) : un critère **phénotypique** est présent. La réduction des apports d'au moins 50 % depuis plus d'une semaine est un

critère **étiologique** : la résidente est **dénutrie**. La perte est inférieure à 15 % : il faut vérifier l'IMC et l'albuminémie pour savoir si la dénutrition est sévère.

L'établissement : sur 84 résidents évalués, 23 sont dénutris, dont 9 de façon sévère. Prévalence = 23 / 84 × 100 = **27,4 %** ; dénutrition sévère = 9 / 84 × 100 = **10,7 %**. Ces valeurs sont dans la fourchette publiée pour les EHPAD (15 à 40 %) ; elles justifient un plan d'action (enrichissement, collations, suivi mensuel du poids).

À vous de jouer – Exercice d'application 2.4 ter

Un homme de 78 ans vivant à domicile pèse 58 kg pour 1,72 m ; il a perdu 4 kg en 6 mois (poids initial 62 kg) et mange moins depuis 3 semaines à cause d'une infection. a) Calculez son IMC et sa perte de poids en pourcentage. b) Posez le diagnostic selon les critères de la HAS. c) Proposez deux indicateurs de suivi pour un programme de repérage à domicile.

Corrigé

a) IMC = 58 / $1{,}72^2$ = 58 / 2,9584 = **19,6** ; perte = 4 / 62 × 100 = **6,5 %** en 6 mois. **b)** Critère phénotypique : IMC inférieur à 22 (et même inférieur à 20). Critères étiologiques : réduction des apports depuis plus de deux semaines et situation d'agression (infection). L'homme est **dénutri** ; l'IMC inférieur à 20 signe une **dénutrition sévère**. **c)** Part des personnes repérées pesées au moins une fois par mois ; part des personnes dénutries ayant bénéficié d'une consultation diététique ou d'un enrichissement dans le mois ; évolution du poids à 3 mois.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 2.3.7 et 2.3.8 – Transitions et fardeau des maladies chroniques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Décrivez en une phrase chacune des quatre phases de la transition démographique.
2. Qui a décrit la transition épidémiologique, et en quelle année ?
3. Définissez la transition nutritionnelle et citez son auteur.
4. Qu'est-ce que le double fardeau de la malnutrition ?
5. Calcul : 5 décès survenus 30 ans avant l'espérance de vie, et 200 personnes vivant un an avec un poids d'incapacité de 0,2. Calculez les AVCI.
6. Citez deux données françaises qui montrent le poids des maladies liées à la nutrition.

Corrigé – Point d'étape 2.3.7 et 2.3.8

1. Phase 1 : natalité et mortalité élevées. Phase 2 : la mortalité baisse. Phase 3 : la natalité baisse. Phase 4 : natalité et mortalité basses, vieillissement.
2. Abdel Omran, 1971.
3. Évolution des régimes alimentaires avec le développement économique et l'urbanisation : plus de produits animaux, de sucres, de graisses et d'aliments transformés, moins d'activité physique (Barry Popkin, 1993).
4. La coexistence de la dénutrition ou des carences et du surpoids ou de l'obésité dans une même population, un même foyer ou une même personne.
5. AVP = 5 × 30 = 150 ; AVI = 200 × 0,2 × 1 = 40 ; AVCI = 190.
6. Exemples : 49 % des adultes en surpoids dont 17 % d'obésité (Esteban, 2015) ; plus de 3,8 millions de personnes traitées pour un diabète en 2023 ; maladies cardio-neurovasculaires, 21,2 % des décès en 2024.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

2.3.9 Mesurer l'association entre un facteur et un problème de santé

Module · Référentiel : C3.3 · CNED : pas de passage correspondant (voir 2.2.2)

Pour savoir si un **facteur** (exposition : boissons sucrées, sédentarité, précarité) est lié à un **problème de santé** (surpoids, caries), l'épidémiologie compare la fréquence du problème chez les **exposés** et chez les **non-exposés**. Les données sont présentées dans un **tableau de contingence** (tableau 2 × 2).

	Malades (surpoids)	Non malades	Total
Exposés (boisson sucrée quotidienne)	a = 36	b = 164	200
Non exposés	c = 30	d = 270	300
Total	66	434	500

Figure 2.10 – Un tableau de contingence 2 × 2

Mesure	Formule	Lecture
Risque chez les exposés (R1)	a / (a + b)	Proportion de malades parmi les exposés
Risque chez les non-exposés (R0)	c / (c + d)	Proportion de malades parmi les non- exposés
Risque relatif (RR)	R1 / R0	RR = 1 : pas d'association ; RR > 1 : facteur de risque ; RR < 1 : facteur protecteur
Différence de risques (DR)	R1 − R0	Excès de risque lié à l'exposition (en points)
Rapport de cotes (odds ratio, OR)	(a × d) / (b × c)	Proche du RR quand la maladie est rare ; utilisé dans les études cas- témoins
Fraction attribuable chez les exposés	(RR − 1) / RR	Part des cas, chez les exposés, attribuable à l'exposition (si la relation est causale)
Fraction attribuable dans la population	pe × (RR − 1) / [1 + pe × (RR − 1)], pe = part d'exposés	Part des cas de toute la population qui disparaîtraient sans l'exposition

Exemple – Calcul détaillé : boissons sucrées et surpoids chez 500 enfants (données fictives)

Données (figure 2.10) : 200 enfants boivent une boisson sucrée chaque jour, dont 36 en surpoids ; 300 n'en boivent pas chaque jour, dont 30 en surpoids.

- **R1** = 36 / 200 = **0,18** (18 %) ; **R0** = 30 / 300 = **0,10** (10 %).
- **RR** = 0,18 / 0,10 = **1,8** : le surpoids est 1,8 fois plus fréquent chez les enfants exposés.
- **DR** = 0,18 − 0,10 = **0,08**, soit **8 points** de plus.
- **OR** = (36 × 270) / (164 × 30) = 9 720 / 4 920 = **1,98** (supérieur au RR, car le surpoids n'est pas rare ici).
- **Fraction attribuable chez les exposés** = (1,8 − 1) / 1,8 = 0,8 / 1,8 = **0,444** : 44 % des cas de surpoids chez les enfants exposés seraient liés à la boisson sucrée quotidienne.
- **Fraction attribuable dans la population** : pe = 200 / 500 = 0,40 ; 0,40 × 0,8 = 0,32 ; 0,32 / (1 + 0,32) =

0,32 / 1,32 = **0,242** : environ un quart des cas de surpoids de l'ensemble des enfants.

- **En nombre** : 66 enfants en surpoids × 0,242 = **16 cas** environ « évitables » si la relation est causale.

Prudence : une enquête transversale montre une **association**, pas une causalité : les enfants qui boivent des sodas ont peut-être aussi d'autres habitudes (écrans, sommeil) et un milieu social différent (**facteurs de confusion**). Les fractions attribuables supposent une relation **causale**, établie par l'ensemble des études (cohortes, essais).

Définition – Facteur de confusion

Facteur lié à la fois à l'exposition et au problème de santé, qui peut créer ou masquer une association. Exemple : le niveau de revenu est lié à la consommation de sodas et au surpoids des enfants ; si l'on n'en tient pas compte, on attribue aux sodas une partie de l'effet du revenu. On le contrôle par la **stratification** (comparer à revenu égal) ou par des méthodes statistiques (ajustement).

À vous de jouer – Exercice d'application 2.5

Dans une enquête auprès de 400 adultes, 120 sautent le petit-déjeuner ; parmi eux, 30 déclarent des grignotages fréquents l'après-midi ; parmi les 280 autres, 42. Calculez R1, R0, RR, DR et interprétez.

Corrigé

R1 = 30 / 120 = **0,25** ; R0 = 42 / 280 = **0,15** ; RR = 0,25 / 0,15 = **1,67** ; DR = 0,25 − 0,15 = **0,10**, soit **10 points**. Les adultes qui sautent le petit-déjeuner déclarent 1,67 fois plus souvent des grignotages fréquents ; association qui peut s'expliquer en partie par d'autres facteurs (horaires de travail, sommeil) : ce n'est pas une preuve de causalité.

Les types d'études et leur niveau de preuve

Type d'étude	Principe	Mesure d'association	Points forts et limites
Étude écologique	Compare des groupes ou des territoires, pas des individus	Corrélation	Rapide, données disponibles ; risque de raisonnement écologique (section 2.4.7)
Enquête transversale	Photographie à un moment donné (Esteban, INCA 3)	Prévalence, RR de prévalence, OR	Décrit une situation ; ne dit pas ce qui vient en premier
Étude cas-témoins	Compare l'exposition passée de malades (cas) et de non-malades (témoins)	Odds ratio	Adaptée aux maladies rares ; biais de mémoire
Étude de cohorte	Suit dans le temps des exposés et des non-exposés (Elfe, NutriNet-Santé, Constances)	Incidence, risque relatif	Établit l'ordre temporel ; longue et coûteuse
Essai contrôlé randomisé	Tire au sort qui reçoit l'intervention	Différence entre groupes, RR	Meilleur niveau de preuve d'une intervention ; pas toujours éthique ni faisable
Méta-analyse	Regroupe statistiquement les résultats de plusieurs études	Mesure combinée	Synthèse la plus solide si les études sont de bonne qualité

À retenir – Les grades des recommandations de la HAS (2013)

- **Grade A** : preuve scientifique établie (essais randomisés de forte puissance, méta-analyses).
- **Grade B** : présomption scientifique (essais de moindre puissance, études de cohorte bien menées).

- **Grade C** : faible niveau de preuve (études cas-témoins, séries de cas).
- **AE** : accord d'experts, en l'absence d'études suffisantes.

Passer de l'association à la causalité

Une association, même forte, n'est pas une preuve de causalité. En 1965, l'épidémiologiste britannique Austin Bradford Hill a proposé des **arguments** qui, réunis, rendent une relation causale plausible.

Argument	Question	Exemple : sel et hypertension
Force de l'association	Le risque relatif est-il élevé ?	Association nette entre apport en sodium et pression artérielle
Constance	Les études concordent-elles, dans plusieurs pays et avec plusieurs méthodes ?	Observée dans de nombreuses populations
Temporalité	L'exposition précède-t-elle l'effet ?	Indispensable : c'est le seul argument obligatoire
Relation dose-effet	Plus d'exposition donne-t-il plus d'effet ?	La pression augmente avec l'apport en sel
Plausibilité biologique	Existe-t-il un mécanisme connu ?	Rétention d'eau et de sodium, rigidité artérielle
Preuve expérimentale	Réduire l'exposition réduit-il l'effet ?	Les essais de réduction du sel font baisser la pression (essais DASH-Sodium)

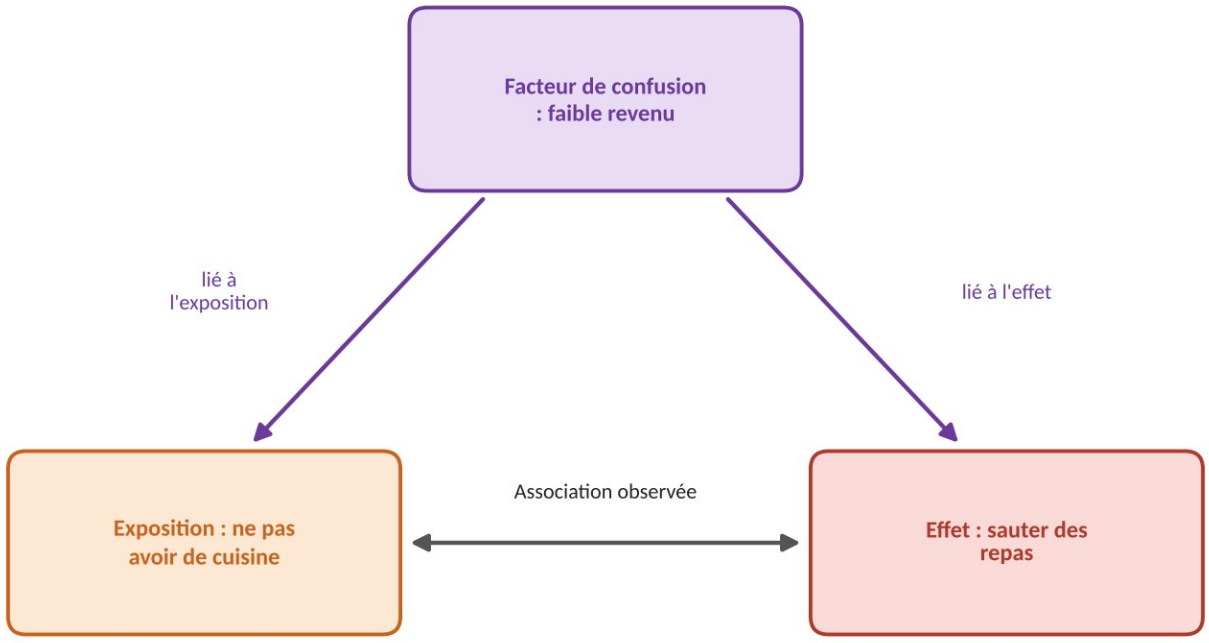


Figure 2.10 bis – Le facteur de confusion

Comprendre le schéma – Figure 2.10 bis

1. On observe une **association** entre une exposition (ne pas avoir de cuisine) et un effet (sauter des repas) : double flèche grise.
2. Un troisième facteur, le **faible revenu**, est lié à l'exposition (les ménages modestes ont plus souvent un logement sans cuisine) et à l'effet (ils sautent plus souvent des repas faute d'argent).
3. Une partie de l'association observée est donc due au revenu : c'est un **facteur de confusion**.

4. Pour le contrôler, on compare les personnes **à revenu égal** (stratification) ou on utilise un ajustement statistique. Si l'association disparaît dans chaque strate, elle était entièrement due à la confusion.

Définition – Les trois grands biais

- **Biais de sélection** : les personnes étudiées ne représentent pas la population visée (volontaires, personnes déjà suivies).
- **Biais d'information (ou de mesure)** : l'exposition ou l'effet sont mal mesurés (poids déclaré, oubli des aliments consommés, désirabilité sociale, biais de mémoire des cas).
- **Biais de confusion** : un facteur lié à l'exposition et à l'effet fausse l'association.

À cela s'ajoute la **causalité inverse** : c'est la maladie qui modifie l'exposition (des personnes en surpoids passent aux boissons « light » ; une association « boissons light et surpoids » ne prouve pas que les boissons light font grossir).

À vous de jouer – Exercice d'application 2.5 bis

Une étude cas-témoins compare 100 adultes ayant fait un infarctus et 200 adultes témoins. 30 cas et 20 témoins déclarent manger de la charcuterie tous les jours. a) Construisez le tableau et calculez l'odds ratio. b) Citez un biais propre aux études cas-témoins. c) Quel facteur de confusion faut-il contrôler ? d) Quels arguments de Bradford Hill manquent ?

Corrigé

a) Exposés : 30 cas, 20 témoins ; non exposés : 70 cas, 180 témoins. OR = (30 × 180) / (70 × 20) = 5 400 / 1 400 = **3,86**. Les personnes ayant fait un infarctus ont environ 3,9 fois plus de chances d'avoir été exposées. **b)** Biais de mémoire : les cas, qui cherchent une explication à leur maladie, se souviennent différemment de leur alimentation. **c)** Le tabac (lié à la consommation de charcuterie et à l'infarctus), mais aussi l'âge, le sexe, le milieu social. **d)** La temporalité n'est pas démontrée par une seule étude rétrospective, ni la relation dose-effet, ni la preuve expérimentale ; il faudrait des cohortes et la constance entre études.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 2.3.9 – Mesurer une association

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez les formules du risque relatif et de l'odds ratio à partir du tableau a, b, c, d.

2. Calcul : 40 des 160 exposés et 30 des 240 non-exposés sont malades. Calculez R1, R0, le RR et la DR.

3. Calculez la fraction attribuable chez les exposés pour ce RR.

4. Que signifie un RR de 0,6 ?

5. Définissez un facteur de confusion et donnez une méthode pour le contrôler.

6. Quel est le seul argument de Bradford Hill indispensable ?

Corrigé – Point d'étape 2.3.9

1. RR = [a / (a + b)] / [c / (c + d)] ; OR = (a × d) / (b × c).

2. R1 = 40 / 160 = 0,25 ; R0 = 30 / 240 = 0,125 ; RR = 0,25 / 0,125 = 2,0 ; DR = 0,25 − 0,125 = 0,125, soit 12,5 points.

3. FAE = (2,0 − 1) / 2,0 = 0,50 : la moitié des cas chez les exposés serait due à l'exposition, si la relation est causale.

4. Le facteur est protecteur : le risque est 40 % plus faible chez les exposés.

5. Facteur lié à la fois à l'exposition et à l'effet, qui crée ou masque une association ; on le contrôle par

stratification ou ajustement.

6. La temporalité : la cause doit précéder l'effet.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

2.3.10 Les inégalités sociales de santé dans le champ de l'alimentation

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §7 (p. 7)

Des inégalités dès l'enfance

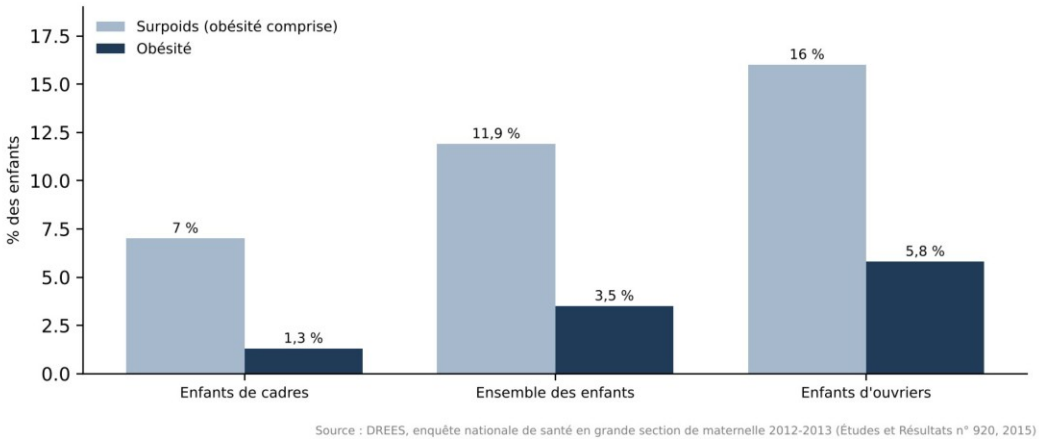


Figure 2.11 – Surpoids et obésité des enfants de grande section selon le milieu social

Comprendre le schéma – Figure 2.11

1. En grande section de maternelle (5-6 ans), **16 %** des enfants d'ouvriers sont en surpoids (obésité comprise) contre **7 %** des enfants de cadres ; pour l'obésité, **5,8 %** contre **1,3 %**.

2. Rapport des prévalences d'obésité : 5,8 / 1,3 = **4,5** : l'obésité est 4,5 fois plus fréquente chez les enfants d'ouvriers ; écart : 5,8 − 1,3 = **4,5 points**.

3. Pour le surpoids : rapport 16 / 7 = **2,3** ; écart **9 points**.

4. Ces écarts existent **avant 6 ans** : ils traduisent les conditions de vie précoces (alimentation, sommeil, écrans, activité physique, environnement), d'où la priorité aux **1000 premiers jours** et aux familles.

5. Ces données datent de 2012-2013 ; elles sont citées dans la plupart des diagnostics car ce sont les dernières données nationales mesurées par milieu social à cet âge. Vérifiez la publication d'enquêtes plus récentes de la DREES (cycle des enquêtes de santé en milieu scolaire).

Alimentation, revenus et insécurité alimentaire

Constat	Données	Source
Insécurité alimentaire	11 % des adultes vivent dans un foyer en situation d'insécurité alimentaire pour raisons financières (2014-2015)	ANSES, INCA 3
Ne pas avoir assez à manger	16 % des Français déclarent ne pas toujours avoir assez à manger (2022), contre 9 % en 2016	Crédoc, 2023

Constat	Données	Source
Aide alimentaire	Environ 5,5 millions de personnes ont eu recours à l'aide alimentaire en 2017	IGAS, 2019
Qualité de l'alimentation	Les personnes les plus diplômées consomment davantage de fruits et légumes et de produits complets ; les moins diplômées davantage de boissons sucrées	INCA 3, Esteban
Obésité adulte	Prévalence nettement plus élevée chez les adultes les moins diplômés et aux revenus les plus faibles	Esteban ; enquêtes Obépi- Roche puis Obépi 2020 (déclaratives)

Mesurer une inégalité : écart absolu et écart relatif

Méthode pas à pas – Deux façons de mesurer une inégalité

- **Écart absolu** (différence) : p(défavorisés) − p(favorisés), en points ; il dit **combien de personnes** de plus sont touchées.
- **Écart relatif** (rapport) : p(défavorisés) / p(favorisés) ; il dit **combien de fois** plus fréquent.

Les deux peuvent évoluer en sens contraire : si l'obésité passe de 2 % à 3 % chez les favorisés et de 6 % à 8 % chez les défavorisés, l'écart absolu **augmente** (4 → 5 points) alors que l'écart relatif **diminue** (6 / 2 = 3 → 8 / 3 = 2,67). Il faut donc toujours préciser quel écart on commente.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.6

Dans une ville, la part d'adultes déclarant consommer 5 fruits et légumes par jour est de 38 % dans les quartiers favorisés et de 19 % en quartier prioritaire. Après un programme, elle passe à 41 % et 26 %. Calculez les écarts absolus et relatifs avant et après et concluez.

Corrigé

Avant : écart absolu 38 − 19 = **19 points** ; rapport 38 / 19 = **2,0**. **Après** : 41 − 26 = **15 points** ; 41 / 26 = **1,58**. **Conclusion** : l'inégalité s'est **réduite**, en valeur absolue et relative, car la progression a été plus forte en quartier prioritaire (+ 7 points contre + 3 points) : c'est l'objectif de l'universalisme proportionné. (Données déclaratives : vérifier qu'aucun biais de désirabilité ne s'est accentué dans le quartier ciblé.)

Six questions pour vérifier qu'une action ne creuse pas les inégalités

Méthode pas à pas – La « lentille inégalités » d'un projet

1. Qui est le plus touché par le problème ? Les données sont-elles présentées par catégorie sociale, par quartier, par sexe ?

2. Qui viendra à l'action ? Lieu, horaires, coût, mode d'inscription (en ligne ou non), langue : chaque choix peut exclure une partie du public.

3. Qui peut appliquer les conseils ? Les recettes et conseils sont-ils compatibles avec un petit budget, une petite cuisine, peu de temps ?

4. L'action agit-elle sur l'environnement ? Une action limitée à l'information profite d'abord aux plus favorisés.

5. Les supports sont-ils accessibles ? Littératie, pictogrammes, traduction, oral plutôt qu'écrit.

6. Comment mesurera-t-on l'effet sur les écarts ? Prévoir des indicateurs par groupe social ou par quartier,

avant et après.

Exemple – Appliquer la lentille à un projet « défi familles à alimentation positive »

Un défi propose à des familles de cuisiner plus de produits bio et locaux pendant six mois, avec inscription en ligne et ateliers le mercredi après-midi. **Question 2** : l'inscription en ligne et le mercredi après-midi excluent les familles sans internet et les parents qui travaillent en horaires décalés. **Question 3** : les produits bio et locaux peuvent dépasser le budget des familles modestes. **Ajustements** : inscription aussi par le centre social et les écoles ; ateliers le samedi matin ; budget de départ (bons d'achat) pour les familles aux revenus modestes ; objectif de participation (au moins la moitié des familles venant des quartiers prioritaires) ; indicateurs par quartier.

2.3.11 Représenter et commenter des données épidémiologiques

Module · Référentiel : C3.3, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 2.2.2)

Choisir l'unité et l'échelle

Unité	Usage
Pourcentage (%)	Prévalences fréquentes (surpoids : 17 %)
Pour 1 000 (‰)	Natalité, mortalité générale, mortalité infantile (environ 4 ‰ en France)
Pour 100 000	Mortalité par cause, incidence des cancers, mortalité cardio-neurovasculaire
Effectif	Petits groupes (« 7 familles sur 12 ») ; nombre absolu de cas pour dimensionner une action

Exemple – Calcul détaillé : passer d'un nombre de cas à un taux pour 100 000

Dans une communauté de communes de 46 500 habitants, on compte **93** décès par maladies cardio-neurovasculaires sur un an.

- Taux brut = 93 / 46 500 = **0,002** ; pour 100 000 : 0,002 × 100 000 = **200 pour 100 000**.
- Sur 3 ans (279 décès), le taux annuel moyen est : 279 / (46 500 × 3) × 100 000 = 279 / 139 500 × 100 000 = **200 pour 100 000** : regrouper plusieurs années **stabilise** les taux des petits territoires.
- Pour comparer à la France, il faut un taux **standardisé** (la population de la communauté est peut-être plus âgée).

Les cartes

Les cartes (atlas de l'ORS, Géodes) représentent les indicateurs par territoire, en **classes** de couleurs (du clair au foncé pour des valeurs croissantes). Pour les lire : vérifier l'**indicateur** (taux standardisé ou brut ?), la **période**, le **découpage** (département, EPCI, commune), les **classes** (bornes, effectifs), et se méfier des petits territoires (taux instables, souvent lissés ou masqués).

Choisir le graphique selon le message

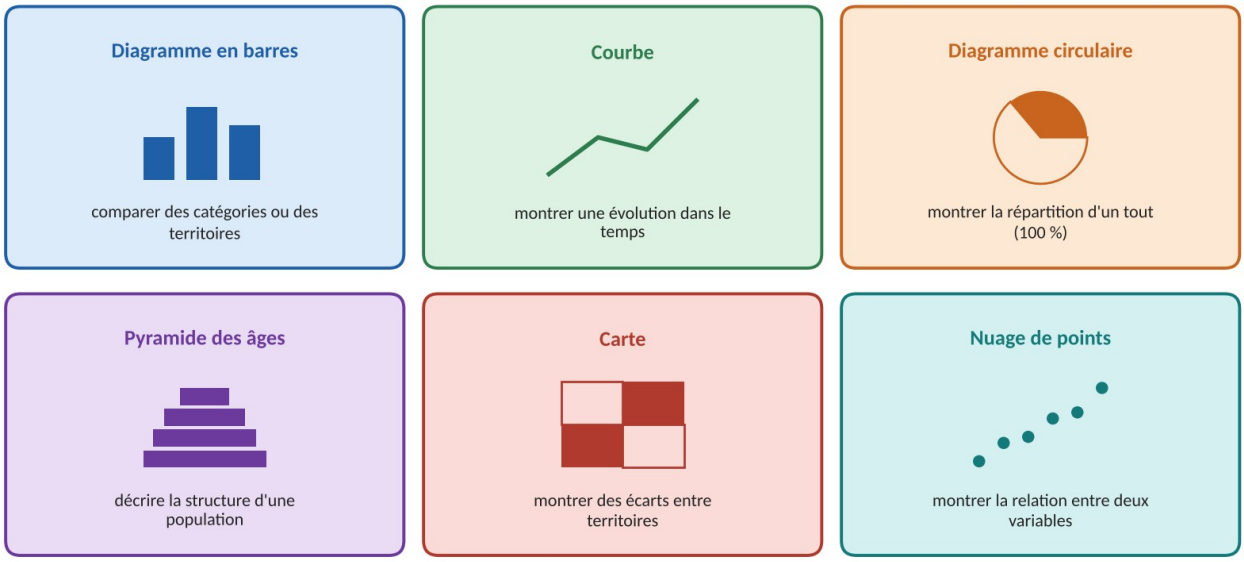


Figure 2.11 bis – Quel graphique pour quel message ?

Comprendre le schéma – Figure 2.11 bis

1. **Diagramme en barres** : comparer des catégories ou des territoires (prévalence du surpoids dans cinq écoles).
2. **Courbe** : montrer une évolution dans le temps (nombre de familles inscrites à l'épicerie solidaire depuis 2020).
3. **Diagramme circulaire** : montrer la répartition d'un tout (100 %), avec peu de catégories (au plus 5 ou 6).
4. **Pyramide des âges** : décrire la structure d'une population par âge et par sexe.
5. **Carte** : montrer des écarts entre territoires (indice comparatif de mortalité par EPCI).
6. **Nuage de points** : montrer la relation entre deux variables mesurées chez les mêmes individus ou territoires (revenu et consommation de fruits).

Méthode pas à pas – Construire un graphique propre pour un dossier

1. Un titre informatif : « Part des enfants de grande section en surpoids selon l'école (bilans de santé 2025-2026) ».

2. Des axes nommés avec leur unité (%, ‰, pour 100 000) ; un axe des barres qui commence à 0.

3. La source et l'effectif sous le graphique (« n = 118 enfants »).

4. Peu de couleurs et une couleur de mise en valeur pour le groupe dont on parle.

5. Une valeur de référence quand elle existe (ligne horizontale « département : 9 % »).

Calcul détaillé – Construire les classes d'une carte (données fictives)

Un ORS veut représenter la part de personnes de 75 ans ou plus dans 9 200 habitants d'un canton, dont 1 240 ont 75 ans ou plus : 1 240 / 9 200 × 100 = **13,5 %**. Pour la carte de toutes les communes, il choisit 4 classes : moins de 9 %, de 9 à moins de 12 %, de 12 à moins de 15 %, 15 % ou plus. Le canton est placé dans la troisième classe (12 à moins de 15 %). **Lecture critique** : la couleur dépend des bornes choisies ; avec une borne à 13 %, le canton changerait de classe. Une carte se lit toujours avec sa légende, sa source et sa date.

Rédiger un commentaire de données

Méthode pas à pas – Commenter un tableau ou un graphique en 5 phrases

1. Présenter : « Ce graphique présente la prévalence de… chez… en… (source, année). »

2. Décrire la tendance générale : « La prévalence augmente avec… »

3. Citer les valeurs extrêmes avec leurs unités : « Elle varie de 1,3 % chez… à 5,8 % chez… »

4. Calculer un écart pertinent : « soit 4,5 fois plus (+ 4,5 points). »

5. Interpréter et nuancer : explication par les déterminants, limites (date, mesure, échantillon) et conséquence pour l'action.

Exemple – Un commentaire complet en 5 phrases

Données (fictives, enquête régionale 2025 auprès de 1 800 collégiennes et collégiens) : part des élèves qui ne prennent jamais de petit-déjeuner les jours d'école : 9 % à 11 ans, 16 % à 13 ans, 24 % à 15 ans.

1. Présenter : « Ce graphique présente la part des collégiens qui ne prennent jamais de petit-déjeuner les jours d'école, selon l'âge (enquête régionale, 2025, n = 1 800). »

2. Tendance : « Cette part augmente nettement avec l'âge. »

3. Valeurs extrêmes : « Elle passe de 9 % à 11 ans à 24 % à 15 ans. »

4. Écart : « Soit 15 points de plus, et une fréquence 2,7 fois plus élevée (24 / 9 = 2,67). »

5. Interpréter et nuancer : « Cette évolution peut s'expliquer par l'autonomie croissante des adolescents, les horaires de sommeil et le souci de l'image du corps ; les données sont déclarées et il faudrait les analyser selon le sexe et le milieu social. Elles invitent à agir dès l'entrée au collège. »

Attention – Les pièges graphiques

Axe des ordonnées qui ne commence pas à zéro pour des barres (il exagère les écarts) ; pourcentages calculés sur des bases différentes comparés entre eux ; secteurs en 3D ; absence de source, de date, d'effectif ; trop de couleurs ; mélange de taux bruts et standardisés.

2.3.12 Les grandes enquêtes et cohortes en nutrition

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Synthèse M3 S1 §1 (p. 26)

Les données locales (Insee, santé scolaire, ORS) décrivent un territoire ; les **grandes enquêtes nationales** décrivent les consommations, l'état nutritionnel et leurs évolutions, et servent de **référence** pour interpréter les données locales.

Enquête ou dispositif	Organisme, période	Contenu	Usage pour le diététicien
INCA (1, 2, 3)	ANSES ; INCA 3 : 2014- 2015	Consommations alimentaires détaillées (enfants et adultes), apports, compléments, comportements, insécurité alimentaire	Comparer les consommations d'un public aux moyennes nationales ; arguments pour les repères
ENNS (2006) puis Esteban (2014-2016)	Santé publique France (ex-InVS)	Consommations et mesures (poids, taille, tour de taille, biomarqueurs : vitamine D, fer, folates)	Prévalences mesurées de surpoids, d'obésité, de carences
Albane	ANSES et Santé publique France (dispositif pérenne en cours de déploiement)	Combinaison des consommations, biomarqueurs et activité physique, cycles réguliers	Futures données de référence (à surveiller)

Enquête ou dispositif	Organisme, période	Contenu	Usage pour le diététicien
Baromètre de Santé publique France	Santé publique France, enquêtes téléphoniques régulières	Comportements de santé déclarés (alimentation, activité physique, tabac, alcool)	Données régionales et sociales
Obépi (1997-2012) puis Obépi 2020	Enquêtes déclaratives (sociétés d'études)	Poids et taille déclarés des adultes	Tendances (sous-estimation du surpoids)
Elfe	Ined, Inserm, depuis 2011	Cohorte de plus de 18 000 enfants suivis de la naissance à l'âge adulte	Alimentation précoce, allaitement, diversification, croissance
NutriNet-Santé	Équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle (EREN), depuis 2009	Cohorte en ligne de plus de 170 000 volontaires adultes	Liens entre alimentation (Nutri-Score, aliments ultra-transformés) et santé
Constances	Inserm, Assurance maladie, depuis 2012	Cohorte généraliste de 200 000 adultes	Déterminants sociaux et professionnels de la santé
Enquêtes de santé en milieu scolaire	DREES, Éducation nationale (cycle grande section, CM2, 3e)	Corpulence mesurée, habitudes de vie, selon le milieu social	Inégalités sociales chez l'enfant
Système national des données de santé (SNDS)	Assurance maladie, Health Data Hub	Consommations de soins, pathologies traitées (diabète, ALD)	Prévalence du diabète traité par territoire (Data pathologies)
Oqali	INRAE, ANSES	Composition nutritionnelle des aliments transformés, évolution des recettes	Suivre la reformulation (sel, sucre)
Ciqual	ANSES	Table de composition nutritionnelle des aliments	Calculs de valeurs nutritionnelles (BPADN)

Les types d'études (transversale, cohorte, essai) et les méthodes d'enquête alimentaire sont présentés aux chapitres 16 et 17.

Exemple – Lire un résultat de cohorte : aliments ultra-transformés et cancer (NutriNet-Santé)

En 2018, l'équipe de la cohorte NutriNet-Santé a publié dans le *BMJ* une étude sur 104 980 adultes suivis en moyenne 5 ans (Fiolet et coll., 2018). Une augmentation de **10 points** de la part des aliments ultra-transformés dans l'alimentation était associée à une augmentation d'environ **12 %** du risque de cancer (rapport de risques instantanés, ou *hazard ratio*, de 1,12, intervalle de confiance à 95 % de 1,06 à 1,18).

Comment le lire : 1) c'est une **cohorte** : l'alimentation a été mesurée avant l'apparition des cancers (temporalité respectée) ; 2) l'intervalle ne contient pas 1 : l'association est **statistiquement significative** ; 3) les auteurs ont **ajusté** sur de nombreux facteurs de confusion (âge, sexe, tabac, activité physique, niveau d'études, IMC…) ; 4) les participants sont des **volontaires**, plus souvent des femmes et plus diplômés que la population (biais de sélection possible) ; 5) une seule étude ne suffit pas : la causalité s'appuie sur la **constance** avec d'autres études et sur des mécanismes plausibles (additifs, contaminants, composition nutritionnelle).

Ce qu'on peut dire à un public : « Des études de suivi montrent que manger beaucoup d'aliments ultra-transformés est associé à plus de risque de certains problèmes de santé ; le PNNS recommande de limiter ces produits et de privilégier le fait-maison et les produits bruts. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 2.3.10 à 2.3.12 – Inégalités alimentaires, données et enquêtes

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les prévalences de l'obésité chez les enfants d'ouvriers et de cadres en grande section, avec l'année.
2. Calcul : 12 % d'obésité dans un groupe et 4 % dans un autre. Calculez l'écart absolu et l'écart relatif.
3. Quel graphique utiliser pour une évolution dans le temps ? Pour une répartition d'un tout ?

4. Citez deux pièges graphiques.
5. Distinguez enquête transversale et cohorte, avec un exemple français de chaque.
6. Que mesure la part de Français déclarant ne pas toujours avoir assez à manger (Crédoc) en 2022 ?

Corrigé – Point d'étape 2.3.10 à 2.3.12

1. 5,8 % chez les enfants d'ouvriers contre 1,3 % chez les enfants de cadres (Drees, données 2012-2013).
2. Écart absolu : 12 − 4 = 8 points ; écart relatif : 12 / 4 = 3,0.
3. Une courbe ; un diagramme circulaire (ou barres empilées à 100 %).
4. Axe des barres qui ne commence pas à zéro ; secteurs en 3D ; absence de source, de date ou d'effectif ; mélange de taux bruts et standardisés.
5. Transversale : photographie à un moment donné (INCA 3, Esteban). Cohorte : suivi dans le temps (Elfe, NutriNet-Santé, Constances).
6. 16 % des Français déclarent ne pas toujours avoir assez à manger en 2022, contre 9 % en 2016 : un indicateur déclaratif de précarité alimentaire.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

2.3.13 Agir sur les déterminants : leviers d'action et évaluation d'impact sur la santé

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : pas de passage correspondant (voir 2.2.2)

Des déterminants aux leviers

Le modèle de Dahlgren et Whitehead ne sert pas seulement à analyser : il permet de **choisir le niveau d'action**. Plus on agit sur les couches extérieures (conditions socio-économiques, environnement), plus l'action touche de personnes et moins elle dépend de la volonté individuelle ; mais elle exige des décideurs et du temps.

Niveau du modèle	Exemple de levier en nutrition	Acteurs
Facteurs individuels (âge, sexe, hérédité)	Non modifiables : ils servent à cibler (personnes âgées, enfants, femmes enceintes)	–
Comportements individuels	Éducation nutritionnelle, ateliers culinaires, entretien motivationnel, information (Nutri-Score)	Diététiciens, éducateurs, médias
Réseaux sociaux et communautaires	Repas partagés, mamans relais, groupes de marche, jardins partagés	Centres sociaux, associations, habitants
Conditions de vie et de travail	Restauration scolaire et d'entreprise de qualité, logement équipé d'une cuisine, épiceries solidaires, accès aux soins	Collectivités, employeurs, CCAS
Conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales	Minima sociaux, taxe sur les boissons sucrées, encadrement de la publicité, politiques agricoles, PAT	État, Union européenne, collectivités

Définition – Santé dans toutes les politiques et évaluation d'impact sur la santé (EIS)

La **santé dans toutes les politiques** (*Health in All Policies*, déclaration d'Helsinki, OMS, 2013) consiste à prendre en compte les effets sur la santé des décisions prises dans les autres secteurs (urbanisme, transport, agriculture, éducation). L'**évaluation d'impact sur la santé** (EIS) est une démarche structurée qui estime, **avant** une décision, ses effets potentiels sur la santé et sur les inégalités, et propose des recommandations (exemple : EIS d'un projet de rénovation urbaine, évaluant l'accès aux commerces alimentaires et aux espaces verts).

Exemple – Une EIS simplifiée : l'implantation d'un supermarché en périphérie

Une commune envisage de transférer son supermarché du centre-ville vers une zone commerciale à 3 km. **Effets possibles** : prix plus bas et offre plus large (positif) ; mais perte d'accès à pied pour les personnes âgées et les ménages sans voiture (négatif), fermeture possible de petits commerces, hausse des déplacements motorisés. **Groupes les plus touchés** : personnes âgées du centre (29 % de 65 ans ou plus), ménages sans voiture (18 %). **Recommandations** : navette gratuite les jours de marché, maintien d'une supérette de proximité, livraison à domicile à tarif social. Le diététicien apporte son expertise sur l'accès à l'alimentation et les publics vulnérables.

Choisir entre plusieurs actions : une grille de priorisation

Quand plusieurs actions sont possibles, on les compare avec des critères explicites. La grille rend le choix **transparent** pour le comité de pilotage.

Calcul détaillé – Grille pondérée (notes de 1 à 5, données fictives)

Critères et poids : impact attendu sur la santé (40 %), faisabilité avec les moyens disponibles (30 %), effet sur les inégalités (30 %).

Action	Impact	Faisabilité	Équité	Score pondéré
Ateliers cuisine petit budget au centre social	3	5	4	0,4 × 3 + 0,3 × 5 + 0,3 × 4 = 3,9
Tarification sociale de la cantine	5	2	5	0,4 × 5 + 0,3 × 2 + 0,3 × 5 = 4,1
Affiches « 5 fruits et légumes »	1	5	1	0,4 × 1 + 0,3 × 5 + 0,3 × 1 = 2,2
Fontaines à eau dans les écoles	3	4	3	0,4 × 3 + 0,3 × 4 + 0,3 × 3 = 3,3

Lecture : la tarification sociale arrive en tête (4,1), malgré une faisabilité faible, parce qu'elle agit sur un déterminant économique et touche d'abord les familles modestes ; les ateliers suivent de près (3,9). Les affiches, faciles mais peu efficaces et peu équitables, arrivent en dernier (2,2). Une stratégie réaliste combine les deux premières : le diététicien anime les ateliers et apporte des arguments chiffrés aux élus pour la tarification.

Attention – Une grille n'est pas neutre

Les notes et les poids sont des **choix** : ils doivent être discutés avec les partenaires et, si possible, avec les habitants. Changer le poids de la faisabilité de 30 % à 50 % peut inverser le classement. Présentez toujours vos critères.

Un cadre international pour agir sur l'environnement alimentaire : NOURISHING

Le cadre **NOURISHING**, proposé en 2013 par le Fonds mondial de recherche contre le cancer (WCRF International), classe les politiques publiques qui améliorent l'environnement alimentaire et les comportements. Chaque lettre du mot anglais correspond à un domaine d'action.

Domaine	Exemple de politique	Exemple en France
Étiquetage nutritionnel	Logo simple sur la face avant des emballages	Nutri-Score (2017, nouvel algorithme depuis 2024)
Offre dans les institutions	Règles nutritionnelles dans les cantines et les hôpitaux	Loi EGalim (2018) : produits durables et de qualité, menu végétarien hebdomadaire à l'école
Outils économiques	Taxes, subventions	Taxe sur les boissons sucrées (2012, modulée en 2018)
Restriction de la publicité	Encadrement du marketing destiné aux enfants	Publicité supprimée des programmes jeunesse de France Télévisions (2018), charte ARCOM
Amélioration de la composition	Réduction du sel, du sucre	Accords collectifs de réduction du sel dans le pain
Environnement de vente	Règles sur l'implantation et la présentation des produits	Interdiction des distributeurs payants dans les écoles (2005)
Partenariats et chaîne alimentaire	Soutien aux circuits courts, à la production locale	Projets alimentaires territoriaux (PAT)
Information du public	Campagnes, repères	Repères du PNNS, site mangerbouger.fr
Conseil nutritionnel en soins	Repérage et accompagnement	Consultations diététiques, éducation thérapeutique
Éducation et compétences	Cuisine, jardinage, éducation alimentaire	Classes du goût, ateliers culinaires

À vous de jouer – Exercice d'application 2.6 bis

Une commune vous demande trois mesures qui agissent sur l'environnement alimentaire plutôt que sur l'information. Proposez-les en citant le domaine NOURISHING correspondant et le niveau du modèle de Dahlgren et Whitehead concerné.

Corrigé

Exemples : 1) introduire plus de légumineuses et de produits bruts dans la cantine (offre dans les institutions ; conditions de vie) ; 2) installer des fontaines à eau dans les écoles et les équipements sportifs (environnement de vente ; conditions de vie) ; 3) soutenir un marché de producteurs dans le quartier prioritaire et des paniers à prix réduit (partenariats et chaîne alimentaire, outils économiques ; conditions de vie et conditions socio-économiques générales).

2.3.14 Les indicateurs de santé de la périnatalité et de l'enfance

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §5 (p. 6)

Les premières années de vie conditionnent la santé future (approche parcours de vie, 1000 premiers jours). Plusieurs indicateurs sont utilisés dans les diagnostics ciblant les familles.

Indicateur	Définition	Source
Taux de mortalité infantile	Décès d'enfants de moins de 1 an / naissances vivantes × 1 000	Insee ; environ 4 ‰ en France, plus élevé dans certains départements et en outre-mer

Exemple – Calcul détaillé : indicateurs de périnatalité d'un département (données fictives)

Naissances vivantes : **7 450** ; décès avant 1 an : **34**, dont **23** avant 28 jours ; naissances prématurées : **597** ; naissances de moins de 2 500 g : **551**.

- Mortalité infantile : 34 / 7 450 × 1 000 = **4,56 ‰**.
- Mortalité néonatale : 23 / 7 450 × 1 000 = **3,09 ‰** ; part de la mortalité infantile survenant avant 28 jours : 23 / 34 × 100 = **67,6 %**.
- Prématurité : 597 / 7 450 × 100 = **8,0 %**.
- Petit poids de naissance : 551 / 7 450 × 100 = **7,4 %**.

Interprétation : la mortalité infantile, avec seulement 34 décès, est un indicateur instable ; on le calcule sur 3 ans. Une prématurité et un petit poids élevés orientent vers la **nutrition de la femme enceinte** (prise de poids, carences, tabac), le suivi de grossesse et la lutte contre la précarité ; ce sont des priorités de PMI et des 1000 premiers jours.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.7

Une PMI a reçu 1 260 certificats du 24e mois ; 151 enfants ont un IMC supérieur au seuil du surpoids ; 504 certificats mentionnent une consommation quotidienne de jus de fruits ou de boissons sucrées. Calculez les proportions, la marge d'erreur de la première et proposez une action.

Corrigé

Surpoids : 151 / 1 260 × 100 = **12,0 %** ; marge : 0,12 × 0,88 = 0,1056 ; / 1 260 = 0,0000838 ; √ = 0,00915 ; × 1,96 = **0,018**, soit ± 1,8 point. Boissons sucrées : 504 / 1 260 × 100 = **40,0 %**. Action : ateliers « boissons et goûters » en salle d'attente de PMI, message clair « l'eau est la seule boisson indispensable », formation des puéricultrices, affiches imagées (chapitre 5). Limite : données de certificats (remplissage parfois incomplet, toutes les familles ne les retournent pas).

Le suivi de la santé de l'enfant : une source de données de proximité

Depuis 2019, l'enfant bénéficie de **20 examens de santé obligatoires** de la naissance à 16 ans, dont 14 au cours des trois premières années ; trois d'entre eux (8e jour, 9e mois, 24e mois) donnent lieu à un **certificat de santé** transmis au service de PMI du département. À l'école, des bilans sont réalisés en grande section (vers 6 ans) et vers 12 ans. Ces données, agrégées et anonymes, sont une source précieuse pour un diagnostic local, sur demande à la PMI ou au service de santé scolaire.

Méthode pas à pas – Interpréter la corpulence d'un enfant

1. Calculer l'IMC : poids / taille², comme chez l'adulte.

2. Le placer sur la courbe de corpulence du carnet de santé (références françaises 2018), selon l'âge et le sexe ; ne jamais utiliser les seuils de l'adulte.

3. Repérer la zone : au-dessus du seuil IOTF-25, surpoids ; au-dessus du seuil IOTF-30, obésité.

4. Regarder la dynamique : un **rebond d'adiposité précoce** (remontée de la courbe avant 6 ans) ou un changement de couloir vers le haut sont des signes d'alerte, même si l'IMC reste dans la zone normale.

Exemple – Pourquoi un même IMC n'a pas le même sens

Un IMC de 18 est normal pour un enfant de 1 an (période où l'IMC est naturellement élevé), proche de la zone de surpoids pour un enfant de 6 ans (période où l'IMC est au plus bas), et en zone de maigreur pour un adulte. C'est pourquoi les prévalences de surpoids de l'enfant ne se calculent qu'avec des **références par âge**

et par sexe.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.7 bis

Une PMI vous transmet les certificats du 24e mois d'une commune : 214 certificats reçus pour 268 naissances deux ans plus tôt ; 23 enfants au-dessus du seuil IOTF-25. a) Calculez le taux de retour des certificats et la prévalence du surpoids. b) Quelle limite le taux de retour impose-t-il ?

Corrigé

a) Taux de retour = 214 / 268 × 100 = **79,9 %**. Prévalence = 23 / 214 × 100 = **10,7 %** des enfants dont le certificat a été reçu. **b)** Un enfant sur cinq n'a pas de certificat : si ces enfants sont plus souvent issus de familles en difficulté (moins de suivi), la prévalence est probablement **sous-estimée** (biais de sélection). Il faut le préciser dans le diagnostic.

2.3.15 Le coût d'une alimentation favorable à la santé

Module · Référentiel et guide : voir 2.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 2.2.2)

Le budget alimentaire des ménages

La part du budget consacrée à l'alimentation **diminue quand le revenu augmente** (loi d'Engel, chapitre 4) : les ménages modestes consacrent une part plus importante de leurs ressources à l'alimentation, et c'est souvent la **variable d'ajustement** quand les dépenses contraintes (logement, énergie, transport) augmentent. L'inflation alimentaire de 2022-2023 (plus de 20 % de hausse cumulée des prix alimentaires en deux ans environ, selon l'Insee) a accentué ces arbitrages : baisse des achats de fruits et légumes, de poisson et de produits sous signe de qualité.

Exemple – Calcul détaillé : le coût d'une journée conforme aux repères (prix fictifs relevés dans un hard-discount)

Aliment (portion)	Quantité	Prix	Coût
Pain complet (petit-déjeuner et repas)	150 g	2,80 €/kg	0,15 × 2,80 = 0,42 €
Lait demi-écrémé	250 mL	1,05 €/L	0,25 × 1,05 = 0,26 €
Yaourt nature	1 × 125 g	0,18 € l'unité	0,18 €
Fruits (pomme, banane)	300 g	2,20 €/kg	0,30 × 2,20 = 0,66 €
Légumes frais et surgelés	400 g	1,90 €/kg	0,40 × 1,90 = 0,76 €
Lentilles sèches	60 g	2,60 €/kg	0,06 × 2,60 = 0,16 €
Riz ou pâtes complètes	80 g	1,80 €/kg	0,08 × 1,80 = 0,14 €
Œufs	2	0,28 € l'unité	2 × 0,28 = 0,56 €
Fromage	30 g	9,00 €/kg	0,03 × 9,00 = 0,27 €
Huile de colza	20 g	2,50 €/L (≈ 2,70 €/kg)	0,02 × 2,70 = 0,05 €
Total de la journée			3,46 €

- Somme : 0,42 + 0,26 + 0,18 + 0,66 + 0,76 + 0,16 + 0,14 + 0,56 + 0,27 + 0,05 = **3,46 €** par personne et par jour.
- Pour un mois de 30 jours : 3,46 × 30 = **103,80 €** par personne ; pour une famille de 4 personnes (en comptant, pour simplifier, 3,2 « équivalents adultes » : 2 adultes + 2 enfants à 0,6) : 103,80 × 3,2 = **332,16 €** par mois.
- Pour une famille disposant de **1 450 €** par mois après paiement du loyer et des charges fixes, ce budget

représente 332,16 / 1 450 × 100 = **22,9 %** des ressources disponibles.

Interprétation : une alimentation conforme aux repères est **possible** à petit prix (légumes secs, légumes de saison et surgelés, œufs, pain complet), mais elle suppose des **compétences** (cuisiner, planifier), du **temps**, un **équipement** et un **accès** à des commerces bon marché ; elle laisse peu de place au poisson, à la viande, aux produits bio ou aux aliments « plaisir » et aux imprévus. C'est pourquoi l'éducation seule ne suffit pas : il faut aussi agir sur les **prix** et les **revenus** (chèques alimentation, épiceries solidaires, tarification sociale des cantines).

Attention – Prix par kilo, prix par portion, prix par calorie

Un même aliment peut paraître cher au kilo et bon marché à la portion (épices, fromage râpé), ou l'inverse. Les aliments denses en énergie (biscuits, chips) coûtent peu **par calorie**, d'où leur attrait pour les budgets serrés ; les fruits, légumes et poissons coûtent plus **par calorie** mais pas forcément **par portion**. En atelier, comparer les prix **par portion** est le plus parlant pour les familles (chapitre 1, fiche F8).

À vous de jouer – Exercice d'application 2.8

Comparez le coût par portion : a) lentilles sèches à 2,60 €/kg (portion 60 g) ; b) steak haché surgelé à 8,90 €/kg (portion 100 g) ; c) œufs à 0,28 € l'unité (portion 2 œufs) ; d) poisson pané à 7,50 €/kg (portion 2 × 50 g). Classez du moins cher au plus cher.

Corrigé

a) 0,060 × 2,60 = **0,16 €** ; b) 0,100 × 8,90 = **0,89 €** ; c) 2 × 0,28 = **0,56 €** ; d) 0,100 × 7,50 = **0,75 €**. Classement : lentilles (0,16 €) < œufs (0,56 €) < poisson pané (0,75 €) < steak haché (0,89 €). Les légumes secs sont la source de protéines la moins chère : argument central d'un atelier « petit budget ».

Calcul détaillé – La loi d'Engel et l'effet de l'inflation (données fictives, par mois)

- **Ménage modeste** : dépenses de consommation 1 400 €, dont 420 € d'alimentation. Part de l'alimentation = 420 / 1 400 × 100 = **30,0 %**.
- **Ménage aisé** : dépenses 4 800 €, dont 780 € d'alimentation. Part = 780 / 4 800 × 100 = **16,3 %** (16,25 %).
- **Hausse de 20 % des prix alimentaires**, à quantités égales : le ménage modeste devrait dépenser 420 × 1,20 = **504 €**, soit 504 / 1 400 × 100 = **36,0 %** de ses dépenses s'il ne peut pas dépenser plus ; le ménage aisé, 780 × 1,20 = 936 €, soit 936 / 4 800 × 100 = **19,5 %**.

Lecture : le ménage aisé absorbe la hausse ; le ménage modeste doit trouver 84 € par mois ailleurs, ou réduire les quantités et la qualité de ses achats (moins de fruits, de légumes, de poisson). C'est le mécanisme qui explique la baisse de ces achats observée pendant l'inflation de 2022-2023.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.8 bis

Une étudiante dispose de 520 € par mois après le loyer ; elle consacre 190 € à l'alimentation. a) Calculez la part de l'alimentation dans son budget. b) Le restaurant universitaire propose un repas à 1 € aux étudiants boursiers ou en difficulté (tarif 2026 à vérifier) : combien économiserait-elle par mois en y prenant 18 déjeuners au lieu de dépenser 3,50 € par déjeuner ? c) Que conclure pour une action de santé publique ?

Corrigé

a) 190 / 520 × 100 = **36,5 %**. **b)** Économie par repas : 3,50 − 1,00 = 2,50 € ; sur 18 déjeuners : 18 × 2,50 = **45,00 €** par mois, soit 45 / 190 × 100 = **23,7 %** de son budget alimentaire. **c)** Faire connaître et faciliter l'accès aux

aides existantes (repas à tarif réduit, épiceries solidaires étudiantes) est une action efficace sur le déterminant économique, souvent plus que des conseils nutritionnels seuls.

2.3.16 Fil rouge : le portrait de santé du quartier des Tilleuls

Module · Référentiel : C3.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 2.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les données rassemblées par Inès (période 1)

Indicateur (données fictives sauf France)	QPV des Tilleuls	Valmont	France
Population	4 200	38 000	69,1 millions
Moins de 18 ans	1 344	7 980	–
65 ans ou plus	504	9 200	22,2 %
Taux de pauvreté	41 %	15 %	14 à 15 %
Familles monoparentales (parmi les familles avec enfants)	28 %	17 %	–
Enfants de grande section en surpoids	14 %	9 % (département)	–
Naissances dans l'année	62	418	645 000

Corrigé – Exploitation des données, pas à pas

Étape 1 – Part des moins de 18 ans : quartier = 1 344 / 4 200 × 100 = **32,0 %** ; commune = 7 980 / 38 000 × 100 = **21,0 %**. Le quartier est nettement plus jeune (rapport 32,0 / 21,0 = 1,52). **Étape 2 – Part des 65 ans ou plus** : quartier = 504 / 4 200 × 100 = **12,0 %** ; commune = 9 200 / 38 000 × 100 = **24,2 %** ; France = 22,2 %. **Étape 3 – Taux brut de natalité** : quartier = 62 / 4 200 × 1 000 = **14,8 ‰** ; commune = 418 / 38 000 × 1 000 = **11,0 ‰** ; France ≈ 9,3 ‰. **Étape 4 – Écarts sociaux** : pauvreté 41 − 15 = **26 points** d'écart (rapport 2,7) ; familles monoparentales 28 − 17 = **11 points**. **Étape 5 – Écart de surpoids des enfants** : 14 − 9 = **5 points**, soit un écart relatif de 5 / 9 × 100 = **55,6 %** (le surpoids est plus fréquent de plus de moitié). **Étape 6 – Constats rédigés** :

1. « Le quartier des Tilleuls est jeune : 32 % de ses habitants ont moins de 18 ans, contre 21 % à Valmont, et sa natalité (14,8 ‰) est supérieure à celle de la commune (11,0 ‰). »
2. « Il concentre la pauvreté : 41 % de taux de pauvreté, soit 2,7 fois celui de la commune, et 28 % de familles monoparentales. »
3. « Le surpoids des enfants de grande section y est plus fréquent (14 %) que dans le département (9 %). »

Conclusion pour le projet : les **familles avec enfants** sont le public prioritaire ; les déterminants **économiques** et l'**environnement alimentaire** doivent être pris en compte ; l'action doit être **accessible financièrement** et **non stigmatisante** (universalisme proportionné).

Fil rouge – centre social des tilleuls – Compléments : les indicateurs avancés calculés par Inès

Structure par âge du quartier (données fictives) : moins de 20 ans : 1 470 ; 20-64 ans : 2 226 ; 65 ans ou plus : 504 ; total : 1 470 + 2 226 + 504 = **4 200** . ✓

- Indice de vieillissement : 504 / 1 470 × 100 = **34,3** seniors pour 100 jeunes (Valmont : environ 110 ; quartier très jeune).
- Rapport de dépendance : (1 470 + 504) / 2 226 × 100 = 1 974 / 2 226 × 100 = **88,7**.

Surpoids des enfants de grande section : 2 écoles, **118 enfants** examinés au bilan de santé.

- Enfants en surpoids : 14 % × 118 = 0,14 × 118 = 16,5, soit **16 ou 17 enfants** (la santé scolaire indique 17).
- Si la prévalence était celle du département (9 %) : 0,09 × 118 = **10,6**, soit environ **11 enfants**.
- **Excès** : 17 − 11 = **6 enfants** environ.

- Rapport des prévalences : 14 / 9 = **1,56** ; fraction des cas du quartier « en excès » par rapport au département : (1,56 − 1) / 1,56 = 0,56 / 1,56 = **0,36**, soit environ un tiers des cas (6 / 17 = 0,35, cohérent).

Insécurité alimentaire : au questionnaire, 19 parents sur 48 déclarent avoir « parfois » ou « souvent » manqué de nourriture dans le mois précédent faute d'argent : 19 / 48 × 100 = **39,6 %**, à rapprocher des 11 % de la population adulte en insécurité alimentaire (INCA 3) et des 16 % de Français déclarant ne pas avoir toujours assez à manger (Crédoc, 2022) ; la marge d'erreur est large (± 13,8 points : 1,96 × √(0,396 × 0,604 / 48) = 1,96 × √0,004983 = 1,96 × 0,0706 = 0,138) mais le constat est net. **Conséquences pour le projet** : les ateliers doivent proposer des recettes **à moins de 1,50 € par personne**, être **gratuits ou presque** (participation symbolique de 2 €), et l'**orientation vers l'épicerie solidaire** devient un objectif à part entière ; Inès signale aussi ce résultat au CCAS (donnée agrégée, sans nom).

Fil rouge – centre social des tilleuls – Compléments : ce que les sources nationales apportent au diagnostic d'Inès

Pour interpréter ses données locales, Inès a utilisé trois références nationales : **INCA 3** (11 % des adultes en insécurité alimentaire ; consommation moyenne de légumineuses très inférieure au repère), **Esteban** (17 % des 6-17 ans en surpoids, 49 % des adultes) et l'**enquête DREES en grande section** (surpoids 16 % chez les enfants d'ouvriers, 7 % chez les enfants de cadres). Elle a rédigé ainsi la partie « contexte » de sa fiche F1 : « *À l'échelle nationale, les comportements alimentaires et le surpoids suivent un gradient social marqué dès l'enfance (DREES, 2015). Dans le quartier des Tilleuls, où le taux de pauvreté atteint 41 %, le surpoids des enfants de grande section (14 %) est supérieur à la moyenne départementale (9 %) et proche de celui observé nationalement chez les enfants d'ouvriers. Près de 4 parents interrogés sur 10 déclarent avoir manqué de nourriture faute d'argent dans le mois précédent (enquête locale, n = 48).* » Ce paragraphe respecte les règles de citation : chaque chiffre a sa **source**, sa **date** et son **champ** ; les données locales (fictives ici) sont distinguées des données nationales ; la taille de l'échantillon local est indiquée.

Cas guidés : du constat à la décision

Cas guidé 1 – Une surmortalité cardio-vasculaire

Cas guidé – Mortalité cardio-vasculaire à Sainte-Claire (données fictives)

La ville de Sainte-Claire (27 000 habitants) observe 234 décès par maladies cardio-neurovasculaires en 3 ans (2021-2023). La population compte 20 400 personnes de moins de 65 ans, 5 600 de 65 à 84 ans et 1 000 de 85 ans ou plus. Les taux annuels de mortalité cardio-neurovasculaire de la région sont de 25 pour 100 000 avant 65 ans, 420 pour 100 000 de 65 à 84 ans et 3 300 pour 100 000 à 85 ans ou plus. Une enquête de l'ORS indique que 65 % des adultes de la ville consomment plus de 8 g de sel par jour ; on retient un risque relatif d'hypertension de 1,4 pour cette exposition.

Corrigé – Étape 1 – Calculer les décès attendus

Décès attendus par an = 20 400 × 25 / 100 000 + 5 600 × 420 / 100 000 + 1 000 × 3 300 / 100 000 = 5,10 + 23,52 + 33,00 = **61,62**. Sur 3 ans : 61,62 × 3 = **184,86** décès attendus.

Corrigé – Étape 2 – Calculer et tester le RSM

RSM = 234 / 184,86 = **1,27** ; indice comparatif = **127**. Intervalle approché des décès observés : 234 ± 1,96 × √234 = 234 ± 30,0, soit 204,0 à 264,0 ; RSM entre 204,0 / 184,86 = **1,10** et 264,0 / 184,86 = **1,43**. L'intervalle ne contient pas 1 : la surmortalité cardio-neurovasculaire est **significative**. Remarque : sur une seule année

(78 décès pour 61,62 attendus), l'intervalle du RSM irait de 0,98 à 1,55 et contiendrait 1 ; c'est en regroupant 3 années que l'écart devient démontrable.

Corrigé – Étape 3 – Mesurer l'enjeu

Décès en excès : 234 − 184,86 = **49,1** en 3 ans, soit environ **16 par an**. Fraction de l'hypertension attribuable au sel dans la population : 0,65 × 0,4 / (1 + 0,65 × 0,4) = 0,26 / 1,26 = **0,206**, soit environ **21 %** des hypertensions, si la relation est causale.

Corrigé – Étape 4 – Décider et argumenter

Constat : « Sainte-Claire présente une surmortalité cardio-neurovasculaire significative de 27 % par rapport à la région, à âge égal (2021-2023), soit environ 16 décès en excès par an. Environ un cinquième des hypertensions de la population serait lié à une consommation de sel supérieure à 8 g par jour. » **Décision proposée** : une action de réduction du sel à l'échelle de la ville, qui agit sur l'environnement (pain moins salé avec les boulangers, restauration scolaire et portage de repas, menus des restaurants d'entreprise) et sur les compétences (ateliers « cuisiner avec moins de sel », lecture des étiquettes), avec un renforcement dans les quartiers les plus modestes. **Indicateurs** : teneur en sel du pain des boulangeries partenaires (mesurée), part des menus de la restauration collective conformes, part d'adultes déclarant saler avant de goûter, avant et après.

Cas guidé 2 – Une action a-t-elle réduit les inégalités ?

Cas guidé – Le programme « Légumes secs en famille » (données fictives)

Une ville a mené pendant un an un programme pour toutes les familles avec enfants : recettes distribuées dans les écoles, dégustations au marché, et, dans le quartier prioritaire seulement, 10 ateliers cuisine gratuits au centre social et des paniers de légumes secs offerts aux participants. La ville compte 1 450 familles avec enfants dans le quartier prioritaire et 2 900 dans les autres quartiers. Un questionnaire identique, posé avant et après à un échantillon de familles, donne la part des familles qui servent des légumes secs au moins deux fois par semaine : quartier prioritaire, 21 % avant et 29 % après ; autres quartiers, 36 % avant et 39 % après. 120 familles du quartier prioritaire et 60 familles des autres quartiers ont participé à au moins un atelier ou une dégustation.

Corrigé – Étape 1 – Mesurer la participation de chaque groupe

Quartier prioritaire : 120 / 1 450 × 100 = **8,3 %** des familles. Autres quartiers : 60 / 2 900 × 100 = **2,1 %**. L'action a touché proportionnellement **4 fois plus** les familles du quartier prioritaire : le renforcement (universalisme proportionné) a fonctionné.

Corrigé – Étape 2 – Mesurer l'évolution des écarts

Avant : écart absolu 36 − 21 = **15 points** ; écart relatif 36 / 21 = **1,71**. Après : 39 − 29 = **10 points** ; 39 / 29 = **1,34**. Progression : + 8 points dans le quartier prioritaire (soit + 38,1 % en valeur relative), + 3 points ailleurs (+ 8,3 %). L'inégalité s'est **réduite** en écart absolu comme en écart relatif.

Corrigé – Étape 3 – Nuancer

Les données sont **déclarées** : les familles qui ont participé aux ateliers peuvent avoir tendance à donner la réponse attendue (biais de désirabilité), surtout dans le quartier prioritaire où l'action était plus intense. Sans

groupe témoin, on ne peut pas attribuer toute l'évolution au programme (une hausse générale des prix de la viande peut aussi avoir joué). Les échantillons doivent être de taille suffisante pour que l'écart soit plus grand que les marges d'erreur.

Corrigé – Étape 4 – Rédiger la conclusion pour le comité de pilotage

« Le programme a touché 8,3 % des familles du quartier prioritaire, contre 2,1 % ailleurs. La part des familles qui servent des légumes secs au moins deux fois par semaine a progressé de 8 points dans le quartier prioritaire et de 3 points ailleurs : l'écart entre les quartiers est passé de 15 à 10 points. Ces résultats déclarés sont encourageants ; nous proposons de reconduire le programme en ajoutant une mesure moins dépendante des déclarations, par exemple le suivi des ventes de légumes secs à l'épicerie solidaire. »

2.4 Approfondissements

2.4.1 Les déterminants commerciaux de la santé

Les stratégies des entreprises (marketing, prix, formulation des produits, lobbying) influencent la santé des populations : on parle de **déterminants commerciaux de la santé** (série du *Lancet*, 2023). En nutrition, l'exposition des enfants à la publicité pour des produits gras, sucrés et salés, la promotion des formats familiaux de boissons sucrées ou l'implantation des commerces de restauration rapide près des écoles en sont des exemples. Le PNNS 5 prévoit de mieux protéger les enfants du marketing alimentaire (charte ARCOM 2025-2029, réflexion sur des restrictions autour des établissements scolaires).

Les quatre leviers des déterminants commerciaux

Levier commercial	Exemple en alimentation	Réponse de santé publique
Produit	Formulation riche en sucres, sel et graisses ; aliments ultra-transformés ; portions agrandies	Reformulation (suivie par l'Oqali), Nutri-Score, accords de réduction du sel dans le pain
Prix	Promotions sur les formats familiaux de boissons sucrées ; prix bas par calorie des produits denses en énergie	Taxe sur les boissons sucrées (France, 2012, modulée selon la teneur en sucres depuis 2018), chèques fruits et légumes
Promotion	Publicité ciblant les enfants, personnages de dessins animés, influenceurs, jeux en ligne	Loi du 20 décembre 2016 supprimant la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de France Télévisions (depuis 2018), charte de l'ARCOM 2025-2029
Place (distribution)	Restauration rapide près des collèges, confiseries aux caisses, distributeurs	Interdiction des distributeurs payants dans les établissements scolaires (2005), règles d'urbanisme, offre de la cantine

Exemple – Analyser un environnement commercial autour d'un collège

Dans un rayon de 500 m autour d'un collège, une stagiaire relève : une boulangerie qui propose une « formule collégien » (viennoiserie et soda) à 2,50 €, deux restaurants rapides, une supérette avec un rayon de boissons sucrées en tête de gondole. **Analyse** : les leviers prix (formule à bas prix), produit (boisson sucrée incluse) et place (proximité) se cumulent. **Pistes** : proposer à la boulangerie une formule alternative (sandwich, fruit, eau) au même prix, travailler avec les collégiens sur le décryptage du marketing (chapitre 5), plaider auprès de la commune pour intégrer ce critère dans l'urbanisme.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.9

Classez chaque pratique selon le levier commercial (produit, prix, promotion, place) et proposez une réponse : a) un « menu enfant » avec jouet ; b) un paquet de biscuits 30 % plus grand « gratuit » ; c) des barres chocolatées placées à hauteur d'enfant près des caisses ; d) un yaourt à boire « source de calcium » très sucré.

Corrigé

a) Promotion (jouet) : encadrement de la publicité et du marketing pour enfants ; travail d'éducation critique avec les familles. **b)** Prix et produit (portion agrandie) : informer sur la taille des portions, Nutri-Score pour comparer. **c)** Place : caisses sans confiseries, action auprès de l'enseigne. **d)** Produit et promotion (allégation qui détourne l'attention du sucre) : apprendre à lire l'étiquette et la liste des ingrédients, comparer avec un yaourt nature.

2.4.2 Mesurer la défavorisation d'un territoire

Pour comparer des territoires, les chercheurs utilisent des **indices de défavorisation** qui combinent plusieurs indicateurs : en France, l'indice **FDep** (Rey et coll., 2009) associe revenu médian, part de bacheliers, part d'ouvriers dans la population active et taux de chômage, à l'échelle de la commune ou de l'IRIS (quartier de 2 000 habitants environ). Il permet par exemple de montrer que la mortalité prématurée augmente du quintile le moins défavorisé au plus défavorisé.

Calcul détaillé – Construire un indice simple de défavorisation par les rangs (données fictives)

On compare quatre quartiers d'une ville. Pour chaque indicateur, on attribue un rang de 1 (le moins défavorisé) à 4 (le plus défavorisé), puis on additionne les rangs.

Quartier	Revenu médian par UC (€ par mois)	Bacheliers parmi les 25 ans ou plus (%)	Ouvriers parmi les actifs (%)	Chômage (%)	Somme des rangs
A	1 250 (rang 4)	28 (rang 4)	41 (rang 4)	24 (rang 4)	16
B	1 610 (rang 3)	45 (rang 2)	35 (rang 3)	13 (rang 2)	10
C	1 980 (rang 2)	41 (rang 3)	22 (rang 2)	16 (rang 3)	10
D	2 450 (rang 1)	63 (rang 1)	12 (rang 1)	8 (rang 1)	4

Règle des rangs : le revenu le plus **bas** et la part de bacheliers la plus **basse** reçoivent le rang 4 ; la part d'ouvriers et le chômage les plus **élevés** reçoivent le rang 4. **Lecture** : le quartier A est le plus défavorisé sur les quatre indicateurs (16, le maximum possible) ; B et C sont ex aequo (10) mais pour des raisons différentes (B a plus d'ouvriers, C plus de chômage) ; D est le moins défavorisé (4, le minimum). **Limite** : la méthode des rangs ne tient pas compte de l'ampleur des écarts ; l'indice FDep utilise une méthode statistique (analyse en composantes principales) qui pondère les indicateurs.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.10

Pourquoi un indice de défavorisation est-il utile à un diététicien qui doit choisir, parmi 12 communes, celles où lancer en priorité des ateliers cuisine ? Citez une limite de l'usage d'un indice communal.

Corrigé

L'indice résume plusieurs dimensions sociales en un seul classement : il permet de **cibler** les communes les plus défavorisées (universalisme proportionné) et de **vérifier** ensuite si les ateliers ont bien touché ces communes. Limite : une commune peu défavorisée en moyenne peut contenir un quartier ou des familles

très pauvres (hétérogénéité interne) ; à l'inverse, toutes les personnes d'une commune défavorisée ne le sont pas (biais écologique).

2.4.3 Les « 1000 premiers jours » et le parcours de vie

L'approche **parcours de vie** montre que l'état de santé à l'âge adulte dépend d'expositions précoces : alimentation de la femme enceinte, allaitement, diversification, environnement de l'enfant. C'est le fondement scientifique du programme « 1000 premiers jours » (2020) et d'une priorité du PNNS 5. Agir tôt est aussi le meilleur moyen de réduire durablement les inégalités.

Définition – Origines développementales de la santé (DOHaD)

Concept issu des travaux de l'épidémiologiste britannique David Barker (fin des années 1980) : un faible poids de naissance était associé, des décennies plus tard, à un risque plus élevé de maladies cardio-vasculaires et de diabète de type 2. L'environnement de la vie fœtale et des premières années (nutrition, stress, toxiques) « programme » en partie la santé future. On parle d'**origines développementales de la santé et des maladies** (DOHaD en anglais).

À retenir – Les 1000 premiers jours en pratique

- Période : de la conception (environ 270 jours de grossesse) aux 2 ans de l'enfant (730 jours).
- Rapport de la **commission des 1000 premiers jours**, présidée par Boris Cyrulnik, remis en septembre 2020 ; il a inspiré le programme gouvernemental et l'application « 1000 premiers jours ».
- Leviers nutritionnels : alimentation et supplémentation de la femme enceinte (acide folique avant la conception), prise de poids adaptée, arrêt de l'alcool et du tabac, allaitement, diversification alimentaire entre 4 et 6 mois révolus, prévention des boissons sucrées et des écrans.
- Acteurs : PMI, sages-femmes, maternités, crèches, centres sociaux, CAF.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.11

Expliquez pourquoi agir pendant les 1000 premiers jours est à la fois une action de prévention des maladies chroniques et une action de réduction des inégalités sociales de santé. Proposez deux indicateurs pour suivre une action dans une PMI.

Corrigé

Prévention : l'alimentation précoce influence la croissance, le goût, la corpulence et le risque futur de diabète et de maladies cardio-vasculaires (DOHaD). Inégalités : les écarts sociaux de surpoids existent dès la grande section (16 % chez les enfants d'ouvriers contre 7 % chez les enfants de cadres) ; agir avant qu'ils ne s'installent est plus efficace que de les corriger ensuite, et les familles modestes sont nombreuses à fréquenter la PMI. Indicateurs : part des enfants allaités à 2 mois et à 6 mois ; part des certificats du 24e mois mentionnant une consommation quotidienne de boissons sucrées ; nombre de familles ayant participé aux ateliers de diversification.

2.4.4 Lire un indicateur avec un esprit critique

Méthode pas à pas – Cinq questions à poser devant un chiffre

1. Qu'est-ce qui est mesuré exactement ? (définition de l'indicateur, numérateur, dénominateur)

2. Chez qui ? (population, âge, territoire)

3. Quand ? (année de recueil, et non de publication)

4. Comment ? (mesuré ou déclaré, échantillon, taille)

5. Par rapport à quoi ? (valeur de référence : département, région, France ; évolution dans le temps ; taux standardisé)

Exemple – Appliquer les cinq questions à un titre de presse

Titre : « L'obésité des enfants a doublé dans notre département ! » **1. Qu'est-ce qui est mesuré ?** L'article parle d'« obésité », mais les chiffres cités sont ceux du **surpoids obésité comprise**. **2. Chez qui ?** Les enfants de grande section **d'une seule circonscription scolaire**, pas tout le département. **3. Quand ?** Comparaison entre l'année scolaire 2015-2016 et 2024-2025. **4. Comment ?** En 2015-2016, poids et taille mesurés par l'infirmière ; en 2024-2025, données issues d'un questionnaire aux parents (déclaratives) sur 74 enfants. **5. Par rapport à quoi ?** Aucune comparaison avec le département ni avec la France. **Conclusion** : le titre n'est pas démontré. On ne compare pas une mesure et une déclaration, ni une circonscription et un département ; avec 74 enfants, la marge d'erreur dépasse 8 points. Le chiffre peut servir d'**alerte** pour demander des données mesurées, pas de constat.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.12

Un document de communication indique : « 1 Français sur 2 en surpoids ! ». Appliquez les cinq questions et proposez une phrase correcte et sourcée.

Corrigé

1. Mesuré : surpoids obésité comprise (IMC ≥ 25). 2. Chez qui : les adultes de 18 à 74 ans, pas tous les Français (les enfants sont à 17 %). 3. Quand : mesures de 2015 (étude Esteban). 4. Comment : poids et taille mesurés, échantillon national. 5. Par rapport à quoi : pas de comparaison ni d'évolution. Phrase correcte : « En 2015, 49 % des adultes de 18 à 74 ans étaient en surpoids, dont 17 % en situation d'obésité (Santé publique France, étude Esteban, mesures). »

2.4.5 L'exposome et les déterminants environnementaux

L'**exposome** désigne l'ensemble des expositions (alimentaires, chimiques, physiques, sociales, psychologiques) d'un individu de sa conception à sa mort. La loi de modernisation de notre système de santé (2016) l'a inscrit dans le Code de la santé publique. En nutrition, il invite à considérer non seulement les nutriments, mais aussi les **contaminants** (pesticides, perturbateurs endocriniens, contaminants de cuisson), les **emballages** (bisphénols, PFAS), le **bruit** et le **stress** ou la **pollution de l'air**, qui interagissent avec l'alimentation. Le **Plan national santé environnement** (PNSE 4, 2021-2025) et l'approche « Une seule santé » (chapitre 1) en sont les cadres ; les messages de prévention correspondants (varier les sources, privilégier les produits frais, limiter le réchauffage dans les plastiques) peuvent compléter un atelier culinaire.

À retenir – Contaminants et alimentation : repères pour un atelier

- **Bisphénol A** : interdit en France dans tous les contenants alimentaires depuis le 1er janvier 2015 (loi du 24 décembre 2012).
- **PFAS** (substances per- et polyfluoroalkylées, « polluants éternels ») : présentes dans certains revêtements et emballages ; très persistantes dans l'environnement.
- **Contaminants de cuisson** : l'acrylamide se forme lors des cuissons à haute température des aliments riches en amidon (frites, chips) ; conseil : ne pas trop colorer.
- **Pesticides** : varier les aliments et les provenances, laver les fruits et légumes ; le PNNS recommande de privilégier les produits issus de l'agriculture biologique quand c'est possible, sans en faire une condition

d'une alimentation favorable à la santé.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.13

Lors d'un atelier, une mère demande : « Si je n'ai pas les moyens d'acheter bio, est-ce que je dois arrêter les fruits et légumes ? » Rédigez votre réponse en trois phrases, en tenant compte de l'exposome et des inégalités.

Corrigé

« Non : les bénéfices des fruits et légumes pour la santé, conventionnels ou bio, sont bien plus importants que les risques liés aux résidus de pesticides. Vous pouvez limiter l'exposition en lavant et en épluchant si besoin, et en variant les fruits, les légumes et les magasins. Les légumes surgelés nature et les fruits de saison sont de bonnes solutions à petit prix. » Le message évite de culpabiliser les familles modestes, qui risqueraient sinon de réduire leur consommation.

2.4.6 Mesurer l'insécurité alimentaire

L'**insécurité alimentaire** se mesure par des questionnaires validés qui explorent l'inquiétude de manquer, la dégradation de la qualité, puis la réduction des quantités : module de l'USDA (18 questions, utilisé dans INCA 3), échelle **FIES** de la FAO (*Food Insecurity Experience Scale*, 8 questions), ou questions courtes de repérage (*Hunger Vital Sign*, 2 questions). On distingue l'insécurité **légère** (inquiétude, qualité), **modérée** (réduction des quantités) et **sévère** (journées sans manger). En diagnostic de terrain, deux questions suffisent pour repérer un besoin : « Au cours des 12 derniers mois, avez-vous craint de manquer de nourriture avant d'avoir de l'argent pour en racheter ? » ; « … la nourriture achetée n'a-t-elle pas duré et vous n'aviez pas d'argent pour en racheter ? ». Ces questions sont sensibles : les poser avec tact, de façon anonyme, en expliquant leur finalité (chapitre 6).

Document – Les 8 questions de l'échelle FIES (FAO), au cours des 12 derniers mois, par manque d'argent ou d'autres ressources

1. Avez-vous été inquiet de ne pas avoir assez de nourriture ?
2. Avez-vous été incapable de manger une nourriture saine et nutritive ?
3. Avez-vous mangé une nourriture peu variée ?
4. Avez-vous dû sauter un repas ?
5. Avez-vous mangé moins que ce que vous pensiez devoir manger ?
6. Votre foyer a-t-il manqué de nourriture ?
7. Avez-vous eu faim mais n'avez pas mangé ?
8. Avez-vous passé une journée entière sans manger ?

Calcul détaillé – Exploiter un repérage simplifié (données fictives, 60 personnes)

Pour un usage de terrain, on compte le nombre de réponses « oui » (score de 0 à 8). Cette lecture simplifiée sert à l'entraînement ; la FAO utilise un modèle statistique (modèle de Rasch) pour classer les personnes.

Score	Lecture simplifiée	Effectif	Part
0	Pas d'insécurité repérée	31	31 / 60 × 100 = 51,7 %
1 à 3	Insécurité légère (inquiétude, qualité)	14	14 / 60 × 100 = 23,3 %
4 à 6	Insécurité modérée (quantités réduites)	11	11 / 60 × 100 = 18,3 %
7 ou 8	Insécurité sévère (faim, journées sans manger)	4	4 / 60 × 100 = 6,7 %

Insécurité modérée ou sévère : (11 + 4) / 60 × 100 = **25,0 %**. **Lecture** : une personne interrogée sur quatre a dû réduire ses quantités ou a eu faim dans l'année. Les 4 personnes en insécurité sévère doivent être orientées sans délai vers l'aide alimentaire et le service social, avec leur accord.

2.4.7 Le piège du raisonnement écologique

Une corrélation observée entre **territoires** ne dit rien des **individus**. Si les communes où l'on vend le plus de restauration rapide ont plus d'obésité, on ne peut pas en conclure que les personnes qui mangent au fast-food sont celles qui sont obèses : c'est le **biais écologique** (*ecological fallacy*). Les données territoriales servent à **orienter** les actions et à **générer des hypothèses** ; seules des données individuelles (enquêtes, cohortes) permettent d'étudier les liens au niveau des personnes.

Exemple – Quand le territoire et les individus racontent deux histoires (données fictives)

La commune X compte 30 points de restauration rapide pour 10 000 habitants et 22 % d'adultes obèses ; la commune Y en compte 12 et 14 % d'obèses. Au niveau des communes, plus de restauration rapide va avec plus d'obésité. Mais une enquête individuelle dans la commune X montre que 18 % des adultes obèses mangent au restaurant rapide chaque semaine, contre 26 % des adultes non obèses. **Lecture** : dans X, ce ne sont pas les personnes obèses qui fréquentent le plus la restauration rapide. Les deux constats peuvent coexister : la commune X est aussi plus pauvre, plus âgée et moins équipée en espaces de sport ; la restauration rapide y est surtout fréquentée par des jeunes actifs et des lycéens. L'association territoriale **oriente** le diagnostic, elle ne prouve rien sur les individus.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.14

Un élu observe que les quartiers de sa ville où l'on vend le plus de fruits et légumes ont moins de diabète. Il propose de distribuer des bons d'achat de fruits uniquement aux personnes diabétiques. Expliquez son erreur de raisonnement et proposez une démarche plus solide.

Corrigé

C'est un **raisonnement écologique** : une corrélation entre quartiers ne dit pas que, chez une même personne, manger des fruits protège du diabète, ni que les diabétiques mangent moins de fruits ; les quartiers diffèrent aussi par le revenu, l'âge, l'activité physique. Démarche : s'appuyer sur des études individuelles (cohortes, essais) qui montrent le rôle de l'alimentation dans la prévention du diabète ; cibler les bons d'achat sur les **ménages modestes** (déterminant économique) plutôt que sur une maladie ; évaluer l'action par des données individuelles avant et après.

2.4.8 Santé mentale et alimentation : une relation dans les deux sens

La santé mentale est à la fois un **déterminant** et une **conséquence** de l'alimentation. D'un côté, la dépression, l'anxiété, les troubles psychiques sévères et certains traitements (antipsychotiques) modifient l'appétit, la motivation pour cuisiner, le poids et la capacité à faire les courses ; le stress chronique lié à la précarité favorise le grignotage d'aliments denses en énergie. De l'autre, l'insécurité alimentaire est associée à plus d'anxiété et de dépression, et une alimentation de type méditerranéen est associée, dans les études d'observation, à un risque plus faible de dépression. Pour le diététicien, cela signifie : repérer les difficultés psychiques sans les diagnostiquer, adapter les conseils (simplicité, régularité des repas, convivialité), travailler avec les équipes de santé mentale et les structures d'entraide.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.14 bis

À l'aide du modèle de Dahlgren et Whitehead, montrez en quatre lignes comment l'isolement social peut agir à la fois sur la santé mentale et sur l'alimentation d'une personne âgée, et proposez une action qui agit sur les deux.

Corrigé

L'isolement (réseaux sociaux et communautaires) favorise la tristesse, la perte d'élan et parfois la dépression ; il réduit aussi l'envie de cuisiner pour soi seul et le plaisir de manger, d'où des repas sautés ou monotones (mode de vie) et un risque de dénutrition. Action : des **repas partagés** réguliers dans un lieu de proximité, avec transport si besoin, qui recréent du lien social et assurent un repas complet.

2.4.9 Femmes et hommes : des écarts de santé à interpréter

Les femmes vivent plus longtemps que les hommes (85,9 ans contre 80,3 ans en 2025, Insee), mais leur avantage est beaucoup plus réduit en **espérance de vie sans incapacité** : à 65 ans, 11,8 ans contre 10,5 ans en 2024 (Drees, 2026) ; une plus grande partie de leurs années de vie supplémentaires est vécue avec des limitations. La surmortalité masculine s'explique en grande partie par des comportements socialement construits (tabac, alcool, prise de risque) et par des métiers plus exposés. En nutrition, les besoins et les risques diffèrent : carence en fer plus fréquente chez les femmes en âge de procréer (pertes menstruelles, grossesses), consommation de viande et d'alcool plus élevée chez les hommes, préoccupations liées au poids plus fréquentes chez les jeunes femmes. Une analyse « genre » du public aide à adapter les messages et les supports, sans enfermer les personnes dans des stéréotypes.

2.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – La standardisation indirecte et l'indice comparatif de mortalité (ICM)

Quand les effectifs par âge sont petits (une commune), les taux spécifiques sont instables. On utilise alors la **standardisation indirecte** : on applique les taux spécifiques d'une **population de référence** (France) à la structure par âge du territoire pour calculer le nombre de **décès attendus** ; l'**indice comparatif de mortalité** (ou SMR, *standardized mortality ratio*) = décès observés / décès attendus × 100. Un ICM de 115 signifie une mortalité supérieure de 15 % à celle de la référence, à structure d'âge égale. Les ORS l'utilisent largement (Score-santé). Son intervalle de confiance permet de dire si l'écart est significatif.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Les indicateurs synthétiques de santé des populations

Les **AVCI** (années de vie corrigées de l'incapacité, *DALY*) additionnent les années de vie perdues par décès prématuré (YLL) et les années vécues avec une incapacité pondérées par sa gravité (YLD). Le projet *Global Burden of Disease* (IHME) estime que les **facteurs de risque alimentaires** (excès de sel, insuffisance de céréales complètes, de fruits, de légumineuses) font partie des principales causes de perte d'années de vie en bonne santé dans le monde. Ces indicateurs aident à hiérarchiser les priorités, mais reposent sur des modèles et des hypothèses discutables.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Causalité sociale ou sélection par la santé ?

Deux hypothèses expliquent l'association entre position sociale et santé : la **causalité sociale** (les conditions de vie dégradent la santé) et la **sélection par la santé** (une mauvaise santé fait perdre son emploi, donc descendre dans l'échelle sociale). Les études longitudinales montrent que les deux mécanismes existent, mais que la causalité sociale est prépondérante, notamment pour les expositions de l'enfance. Les approches de **l'épidémiologie sociale** (Berkman, Kawachi) et de l'**intersectionnalité** (cumul de plusieurs positions

défavorables : genre, origine, revenu) enrichissent cette analyse.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Inégalités et alimentation : le coût de l'alimentation saine

Plusieurs travaux (notamment ceux de Nicole Darmon, INRAE) ont montré qu'à budget contraint, les aliments **denses en énergie** et pauvres en nutriments coûtent moins cher **par calorie**, alors que les fruits, légumes et poissons coûtent plus cher par calorie, mais pas toujours plus cher **par portion** ou par nutriment. Ils ont aussi montré qu'il est possible de composer une alimentation équilibrée à petit budget en privilégiant certains aliments (légumineuses, céréales, légumes de saison, œufs, produits laitiers), à condition d'avoir les compétences, l'équipement et le temps : c'est le fondement des ateliers « petit budget ».

Pour aller plus loin – niveau L3 – Intervalle de confiance d'un taux : l'instabilité des petits nombres

Un taux calculé sur peu d'événements est **imprécis**. Pour un nombre de cas D (loi de Poisson), un intervalle de confiance approché à 95 % du nombre de cas est **D ± 1,96 × √D**. Exemple : 9 décès par diabète dans une commune de 12 000 habitants : taux = 9 / 12 000 × 100 000 = **75 pour 100 000** ; √9 = 3 ; 1,96 × 3 = 5,88 ; nombre de cas entre 9 − 5,88 = 3,12 et 9 + 5,88 = 14,88 ; taux entre 3,12 / 12 000 × 100 000 = **26** et 14,88 / 12 000 × 100 000 = **124 pour 100 000**. Un écart avec la moyenne nationale peut donc n'être que l'effet du hasard : d'où le regroupement de plusieurs années et la prudence dans les comparaisons de petites communes. (Pour moins de 20 cas, on utilise de préférence des intervalles exacts.)

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le paradoxe de Simpson

Une association peut s'**inverser** quand on tient compte d'un troisième facteur. Exemple : un programme semble moins efficace dans la ville A (40 % de réussite) que dans la ville B (46 %) ; mais à niveau socio-économique égal, A fait mieux dans chaque groupe (55 % contre 50 % chez les favorisés ; 35 % contre 30 % chez les défavorisés). L'explication : A accueille beaucoup plus de participants défavorisés (75 % de son public, contre 20 % pour B), qui réussissent moins dans les deux villes. Vérification pour A : 0,25 × 55 + 0,75 × 35 = 13,75 + 26,25 = **40 %** ; pour B : 0,80 × 50 + 0,20 × 30 = 40 + 6 = **46 %**. Toujours comparer des groupes **comparables** (standardisation, stratification).

2.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Tenir compte des déterminants en consultation

Lors d'un bilan diététique, le diététicien recueille les **déterminants** de la personne (revenus, logement, équipement de cuisine, horaires, culture, isolement) : ce sont les mêmes que ceux du diagnostic de santé publique, à l'échelle individuelle. Un plan de soin qui les ignore a peu de chances d'être suivi.

Situation bc2 – Restauration scolaire et inégalités

Pour beaucoup d'enfants de familles modestes, le repas de la cantine est le repas le plus équilibré de la journée. La **tarification sociale**, la qualité nutritionnelle (GEM-RCN, EGalim) et l'accès effectif à la cantine sont des leviers majeurs de réduction des inégalités nutritionnelles.

Situation bc3 – Comparer deux quartiers

Une ARS vous demande pourquoi elle devrait financer une action dans le quartier A plutôt que dans le quartier B. Vous présentez des **taux standardisés**, des indicateurs sociaux (taux de pauvreté, part de familles monoparentales) et d'environnement alimentaire, comparés à la moyenne de la commune et du département, avec leurs sources.

Situation bc3 – Un diagnostic incomplet

Un collègue a construit un diagnostic avec seulement des données nationales (« 17 % des adultes sont obèses en France »). Vous lui montrez qu'un diagnostic de santé publique exige des données **locales**, **sociales** et **datées**, et des **besoins exprimés** par la population.

Situation bc3 – Un territoire vieillissant

Une communauté de communes dont l'indice de vieillissement dépasse 150 sollicite le diététicien : il oriente le diagnostic vers la dénutrition et l'isolement des seniors, mobilise les données de l'ORS et les services d'aide à domicile, et propose une action financée par la conférence des financeurs.

Situation bc3 – Une association à expliquer

Un élu affirme, à partir d'une carte, que « les quartiers avec le plus de restauration rapide ont le plus d'enfants obèses, donc il faut fermer les fast-foods ». Le diététicien explique le biais écologique et les facteurs de confusion (revenus), et propose d'agir sur l'ensemble de l'environnement alimentaire et des déterminants sociaux.

Méthode 1 – Présenter un diagnostic de territoire à l'oral en 3 minutes

À l'oral de l'épreuve E5, le jury vous demande souvent : « Présentez-nous le public et le territoire de votre projet. » Il attend une réponse **structurée**, **chiffrée** et **sourcée**, qui débouche sur un choix.

Méthode pas à pas – Le plan en 5 temps

1. Le territoire (20 secondes) : nom, type (quartier prioritaire, commune rurale), nombre d'habitants, source et année.

2. La population (30 secondes) : deux ou trois indicateurs démographiques comparés à une référence (part des moins de 18 ans ou des 75 ans ou plus, familles monoparentales).

3. La situation sociale (30 secondes) : taux de pauvreté, chômage ou diplôme, comparés à la commune et à la France.

4. La santé et l'alimentation (60 secondes) : un indicateur de santé (surpoids des enfants, mortalité prématurée, diabète traité) et un résultat de votre recueil local (questionnaire, entretiens), avec l'effectif.

5. La conclusion (40 secondes) : le public prioritaire, les deux déterminants principaux, et le lien avec votre action.

À l'oral – Exemple de réponse

« Mon stage s'est déroulé au centre social du quartier du Moulin, un quartier prioritaire de 5 600 habitants. Le quartier est jeune : 29 % des habitants ont moins de 18 ans, contre 20 % dans la commune ; un tiers des familles sont monoparentales. Le taux de pauvreté atteint 36 %, presque trois fois celui de la commune. Selon les bilans de santé scolaire, 17 % des enfants de CE1 sont en surpoids, contre 11 % dans le département, sur 112 enfants examinés. Dans mon questionnaire auprès de 52 parents, 4 sur 10 disent avoir manqué de nourriture faute d'argent dans le mois. J'en ai conclu que le public prioritaire était les familles avec enfants, et

que les déterminants principaux étaient le budget et l'accès à des produits frais : c'est pourquoi mon action associe ateliers cuisine petit budget et partenariat avec l'épicerie solidaire. » (Données de l'exemple fictives.)

Ce que le jury attend – Les erreurs fréquentes relevées par les jurys

- Des chiffres **sans source ni année**, ou des données nationales présentées comme locales.
- Des **taux bruts** comparés entre territoires d'âges différents.
- Des pourcentages calculés sur de **très petits effectifs** (« 50 % des participants » pour 2 personnes sur 4) sans le dire.
- Un diagnostic qui décrit **uniquement les manques**, sans les ressources du territoire.
- Des **déterminants** réduits aux comportements individuels (« les familles mangent mal ») sans les conditions de vie.
- Un diagnostic qui ne débouche sur **aucun choix** : le jury veut comprendre pourquoi ce public, pourquoi cette action.

Méthode 2 – Répondre à une question « Calculez et interprétez »

Méthode pas à pas – Les 4 lignes attendues

1. Formule en toutes lettres : « Taux standardisé = décès attendus dans la population de référence / population de référence × 1 000. »

2. Application numérique avec les données de l'énoncé, sans sauter d'étape.

3. Résultat arrondi (une ou deux décimales) avec son **unité** : %, ‰, pour 100 000, €, AVCI.

4. Interprétation : une phrase qui compare à une référence et une phrase qui dit ce que cela change pour l'action.

À vous de jouer – Exercice d'application 2.15

En une phrase chacune, interprétez pour un comité de pilotage : a) un risque relatif de 0,7 entre la consommation de fruits et le risque de maladie cardio-vasculaire ; b) un indice comparatif de mortalité prématurée de 135 ; c) une prévalence de l'obésité de 21 % (± 6 points) chez 180 adultes volontaires.

Corrigé

a) « Les personnes qui consomment le plus de fruits ont un risque de maladie cardio-vasculaire inférieur de 30 % à celui des autres : la consommation de fruits est un facteur protecteur. » **b)** « Avant 65 ans, on meurt 35 % plus souvent sur ce territoire que dans la région, à âge égal : la prévention y est prioritaire. » **c)** « Environ un participant sur cinq est obèse, avec une marge d'erreur de 6 points ; comme il s'agit de volontaires, ce chiffre ne peut pas être généralisé à toute la population. »

Méthode 3 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve

À vous de jouer – Vrai ou faux commentés

Pour chaque affirmation, dites si elle est vraie ou fausse et justifiez en une phrase.

1. « Un taux de mortalité de 12 ‰ montre que la population est en mauvaise santé. »
2. « Une prévalence se calcule sur la population à risque. »
3. « L'espérance de vie à la naissance est une prévision pour les bébés nés cette année. »

4. « Un RR de 1,05 avec un intervalle de 0,90 à 1,22 montre une association. »
5. « Les inégalités sociales de santé ne concernent que les personnes pauvres. »
6. « Un indice comparatif de 115 signifie 15 % de décès en plus que la référence, à âge égal. »
7. « On peut comparer une obésité mesurée en 2015 et une obésité déclarée en 2024 pour conclure à une hausse. »
8. « Une enquête de cohorte permet d'établir que l'exposition précède la maladie. »
9. « Le niveau de vie est le revenu du ménage. »
10. « La fraction attribuable suppose que la relation est causale. »
11. « Doubler l'effectif d'un échantillon divise la marge d'erreur par deux. »
12. « Une action d'information identique pour tous réduit toujours les inégalités. »
13. « Le solde naturel de la France est devenu négatif en 2025. »
14. « Un facteur de confusion est lié seulement à l'exposition. »
15. « Les données territoriales permettent de conclure au niveau des individus. »

Corrigé – Vrai ou faux commentés

1. Faux : un taux brut dépend de l'âge de la population ; il faut un taux standardisé et une référence.
2. Faux : la prévalence se calcule sur toute la population ; c'est l'incidence qui se rapporte à la population à risque.
3. Faux : c'est une photographie de la mortalité de l'année, appliquée à une génération fictive.
4. Faux : l'intervalle contient 1, l'association n'est pas démontrée.
5. Faux : il existe un gradient social, la santé s'améliore à chaque échelon de l'échelle sociale.
6. Vrai : l'indice comparatif est le rapport standardisé de mortalité multiplié par 100.
7. Faux : les méthodes diffèrent ; les données déclarées sous-estiment l'obésité.
8. Vrai : c'est l'intérêt principal de la cohorte (argument de temporalité).
9. Faux : c'est le revenu disponible divisé par le nombre d'unités de consommation.
10. Vrai : sinon, supprimer l'exposition ne supprimerait pas les cas.
11. Faux : il faut multiplier l'effectif par quatre pour diviser la marge par deux.
12. Faux : elle profite d'abord aux plus favorisés et peut creuser les écarts (effet Matthieu).
13. Vrai : environ − 6 000, pour la première fois depuis 1945 (Insee, 2026).
14. Faux : il est lié à la fois à l'exposition et à l'effet.
15. Faux : c'est le biais écologique ; il faut des données individuelles.

Mon score	Ce que je fais
13 à 15 sur 15	Je suis prêt pour les annales du chapitre.
9 à 12 sur 15	Je relis les sections correspondant à mes erreurs.
Moins de 9 sur 15	Je refais les points d'étape et les exercices d'application.

2.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Déterminants et inégalités

- **Déterminant de santé** : facteur qui influence l'état de santé ; modifiable ou non ; favorable ou défavorable.
- **Lalonde (1974)** : biologie, environnement, habitudes de vie, organisation des soins. **Dahlgren et**

Whitehead (1991) : 5 couches. **OMS (2008)** : déterminants structurels (contexte, position sociale) et intermédiaires (conditions matérielles, psychosociaux, comportements, système de santé).

- **Inégalités sociales de santé** : différences systématiques, évitables et injustes ; **gradient social** ; mécanismes matériels, psychosociaux, comportementaux, d'accès aux soins, de parcours de vie.
- **Inégalités territoriales** : outre-mer, nord et nord-est de l'Hexagone, QPV, rural ; déserts et marais alimentaires.
- **Précarité alimentaire** : définie par la loi EGalim (art. L. 266-1 CASF) ; 16 % des Français concernés (Crédoc, 2022).

À retenir – Indicateurs et formules

Indicateur	Formule ou définition
Taux brut de natalité	Naissances / population moyenne × 1 000
ICF	Nombre moyen d'enfants par femme (1,56 en 2025)
Taux brut de mortalité	Décès / population moyenne × 1 000
Taux spécifique	Décès du groupe / population du groupe × 1 000
Taux standardisé (direct)	(taux spécifiques × population de référence) / population de référence Σ
Mortalité infantile	Décès < 1 an / naissances vivantes × 1 000
Prévalence	Cas existants / population à un instant
Incidence	Nouveaux cas / population à risque au début de la période
Espérance de vie (2025)	85,9 ans (F) ; 80,3 ans (H)
EVSI à 65 ans (2024)	11,8 ans (F) ; 10,5 ans (H)

À retenir – Chiffres-clés

- 69,1 millions d'habitants au 1er janvier 2026 ; 22,2 % ont 65 ans ou plus ; solde naturel négatif en 2025 (Insee).
- 641 046 décès en 2024 : tumeurs 27,1 %, maladies cardio-neurovasculaires 21,2 % (Drees, Inserm-CépiDc, 2026).
- ≈ 13 ans d'écart d'espérance de vie entre les hommes les plus aisés et les plus modestes (Insee, 2018).
- Obésité : 18,1 % (24,7 % en cas de difficultés économiques, 22,4 % en outre-mer) (OFÉO, 2024).

À retenir – Compléments : transitions, fardeau, associations

- **Transition démographique** : natalité et mortalité élevées → baisse de la mortalité → baisse de la natalité → régime moderne (vieillissement). **Épidémiologique** (Omran, 1971) : des maladies infectieuses aux maladies chroniques (≈ 74 % des décès dans le monde). **Nutritionnelle** (Popkin) : vers plus de produits animaux, sucres, graisses, aliments transformés ; **double fardeau** de la malnutrition.
- **Vieillissement** : indice = 65 ans ou plus / moins de 20 ans × 100 ; rapport de dépendance = (moins de 20 + 65 ou plus) / 20-64 × 100.
- **Fardeau** : 49 % des adultes en surpoids dont 17 % obèses (Esteban 2015) ; diabète traité > 5 % ; 41 % des cancers attribuables à des facteurs modifiables (CIRC, 2018) ; AVCI = AVP + AVI ; risques alimentaires : 11 millions de décès dans le monde (GBD 2017).
- **Association** : RR = R1 / R0 ; DR = R1 − R0 ; OR = ad / bc ; fraction attribuable = (RR − 1) / RR ; association ≠ causalité ; **facteur de confusion**.
- **Inégalités alimentaires** : obésité en grande section 5,8 % (ouvriers) contre 1,3 % (cadres) ; insécurité alimentaire 11 % (INCA 3) ; 16 % n'ont pas toujours assez à manger (Crédoc, 2022) ; écart absolu (points) et relatif (rapport).

2.8 Entraînement

2.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Le modèle de Lalonde (1974) comprend :

a) la biologie humaine **b)** l'environnement **c)** les habitudes de vie **d)** l'organisation des soins

QCM 2 – Dans le cadre de l'OMS (2008), sont des déterminants structurels :

a) le niveau d'éducation **b)** le revenu **c)** la consommation de fruits **d)** le contexte politique et les politiques sociales

QCM 3 – Le gradient social de santé signifie que :

a) seuls les plus pauvres ont une moins bonne santé **b)** la santé s'améliore à chaque échelon de l'échelle sociale **c)** il faut agir uniquement auprès des plus défavorisés **d)** les inégalités concernent toute la population

QCM 4 – Une inégalité sociale de santé est :

a) toute différence de santé entre deux groupes **b)** une différence systématique, évitable et injuste **c)** socialement produite **d)** toujours d'origine génétique

QCM 5 – L'espérance de vie à la naissance :

a) est l'âge moyen au décès **b)** dépend de la structure par âge de la population **c)** se calcule à partir des taux de mortalité par âge de l'année **d)** était de 85,9 ans pour les femmes en France en 2025

QCM 6 – L'indicateur conjoncturel de fécondité en France en 2025 est de :

a) 2,1 **b)** 1,83 **c)** 1,56 **d)** 1,2

QCM 7 – Pour comparer la mortalité de deux départements, on utilise de préférence :

a) le nombre de décès **b)** le taux brut de mortalité **c)** le taux standardisé sur l'âge **d)** l'espérance de vie

QCM 8 – Le taux de mortalité infantile rapporte les décès d'enfants de moins d'un an :

a) à la population totale **b)** aux naissances vivantes **c)** aux enfants de moins de 5 ans **d)** aux femmes en âge de procréer

QCM 9 – La prévalence :

a) mesure les nouveaux cas **b)** mesure les cas existants **c)** augmente quand la durée de la maladie augmente **d)** est diminuée par la prévention secondaire

QCM 10 – Première cause de décès en France en 2024 :

a) les maladies cardio-neurovasculaires **b)** les tumeurs **c)** les accidents **d)** la COVID-19

QCM 11 – L'EVSI à 65 ans en France en 2024 est d'environ :

a) 12 ans pour les femmes **b)** 10,5 ans pour les hommes **c)** 20 ans pour les deux sexes **d)** 5 ans

QCM 12 – Les données de causes médicales de décès sont produites par :

a) l'Insee **b)** l'Inserm-CépiDc **c)** la HAS **d)** la CNIL

QCM 13 – Un « marais alimentaire » désigne :

a) une zone sans aucun commerce alimentaire **b)** une zone saturée d'offre de restauration rapide et d'aliments peu favorables **c)** un marché de producteurs **d)** une zone humide agricole

QCM 14 – La lutte contre la précarité alimentaire est définie dans :

a) le Code de l'action sociale et des familles (art. L. 266-1, loi EGalim) **b)** la Charte d'Ottawa **c)** le règlement INCO **d)** le Code du travail

QCM 15 – Le rapport de dépendance se calcule ainsi :

a) (moins de 20 ans + 65 ans ou plus) / (20-64 ans) × 100 **b)** 65 ans ou plus / moins de 20 ans × 100 **c)** naissances / décès **d)** actifs / inactifs

QCM 16 – Le solde naturel de la France en 2025 est :

a) fortement positif **b)** nul **c)** négatif pour la première fois depuis 1945 **d)** inconnu

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, b, c, d : les quatre composantes du « champ de la santé ».

2. a, b, d : la consommation de fruits est un comportement, donc un déterminant intermédiaire.

3. b, d : d'où l'universalisme proportionné ; agir seulement auprès des plus pauvres ignore le gradient.

4. b, c : la différence d'espérance de vie hommes/femmes n'est pas entièrement une inégalité sociale ; les ISS ne sont pas génétiques.

5. c, d : l'espérance de vie est indépendante de la structure par âge ; ce n'est pas l'âge moyen au décès.

6. c : 1,56 enfant par femme (Insee, 2026) ; 2,1 est le seuil de remplacement.

7. c (et **d** est aussi acceptable car l'espérance de vie est indépendante de la structure par âge) ; jamais le nombre de décès ni le taux brut.

8. b.

9. b, c, d : a définit l'incidence.

10. b : tumeurs (27,1 %), devant les maladies cardio-neurovasculaires (21,2 %).

11. a, b (Drees, 2026 : 11,8 ans pour les femmes et 10,5 ans pour les hommes en 2024).

12. b.

13. b : le désert alimentaire correspond à la réponse a.

14. a.

15. a : la réponse b est l'indice de vieillissement.

16. c : − 6 000 en 2025 (Insee).

QCM 17 – L'indice de vieillissement :

a) rapporte les 65 ans ou plus aux moins de 20 ans **b)** vaut 150 quand il y a 150 seniors pour 100 jeunes **c)** est un taux de mortalité **d)** oriente le choix du public prioritaire

QCM 18 – La transition nutritionnelle se caractérise par :

a) une hausse des produits animaux et des sucres ajoutés **b)** une hausse de l'activité physique **c)** une hausse du surpoids et des maladies chroniques **d)** une alimentation plus riche en légumineuses

QCM 19 – 36 malades sur 200 exposés et 30 sur 300 non-exposés donnent un risque relatif de :

a) 1,2 **b)** 1,8 **c)** 0,08 **d)** 6

QCM 20 – Un facteur de confusion :

a) est lié à l'exposition et au problème de santé **b)** peut créer une association trompeuse **c)** se contrôle par stratification ou ajustement **d)** prouve la causalité

QCM 21 – Les AVCI :

a) additionnent années de vie perdues et années vécues avec incapacité **b)** ne tiennent compte que des décès **c)** représentent des années de vie en bonne santé perdues **d)** sont utilisées par l'étude Global Burden of Disease

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM complémentaires

16. a, b, d. 17. **a, c**. 18. **b** (0,18 / 0,10 = 1,8). 19. **a, b, c**. 20. **a, c, d**.

2.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : le champ de la santé

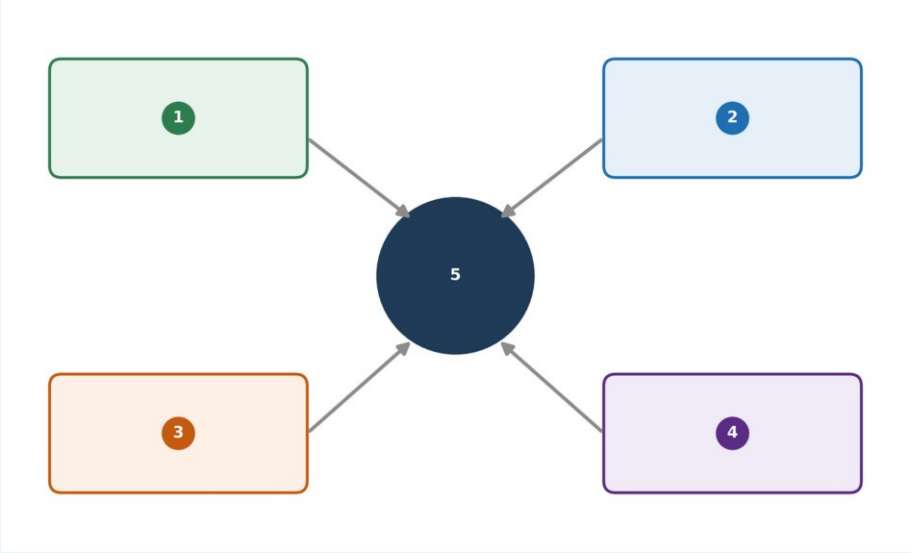


Figure 2.7 – Schéma à légender

Légendez les cases 1 à 5, donnez l'auteur et la date du modèle, et un exemple nutritionnel pour chaque champ.

Corrigé

Modèle de **Marc Lalonde (Canada, 1974)**. 1. **Biologie humaine** (ex. : prédisposition génétique au diabète de type 2). 2. **Environnement** (ex. : offre alimentaire du quartier, qualité de l'eau). 3. **Habitudes de vie** (ex. : consommation de boissons sucrées, sédentarité). 4. **Organisation des soins** (ex. : accès à une consultation diététique, dépistage de la dénutrition). 5. **État de santé**.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : la pyramide des âges

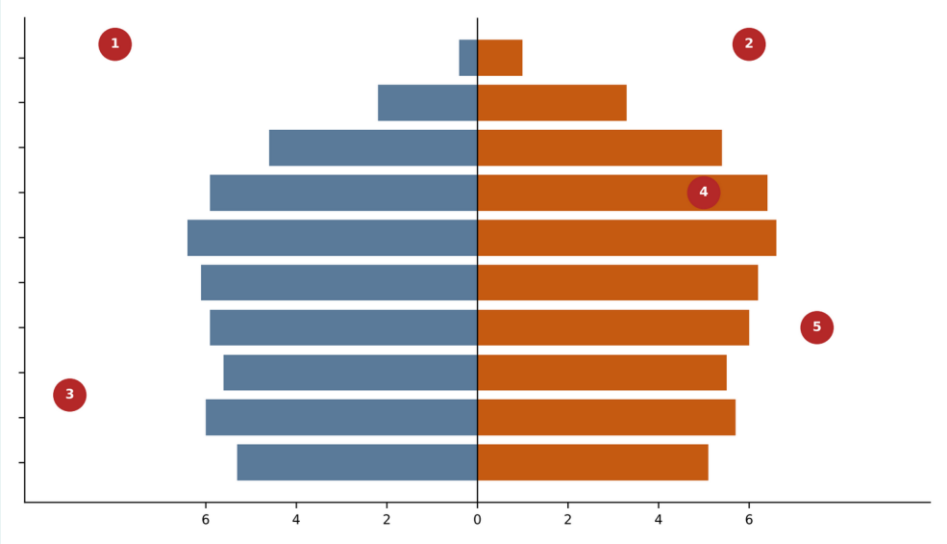


Figure 2.8 – Pyramide à légender

Légendez les repères 1 à 5 et proposez deux priorités nutritionnelles pour ce territoire.

Corrigé

1. Hommes (partie gauche). 2. **Femmes** (partie droite). 3. **Base rétrécie** : baisse de la natalité. 4. **Sommet élargi côté femmes** : vieillissement et surmortalité masculine. 5. **Renflement** des générations du baby- boom (50-69 ans), qui vont accroître le nombre de personnes âgées dans les 10 à 20 prochaines années. **Priorités** : prévention de la dénutrition et de la sarcopénie (portage de repas, ateliers « bien vieillir ») ; prévention des maladies chroniques chez les 50-69 ans (activité physique, alimentation).

À vous de jouer – Exercice 3 – Taux bruts et solde naturel

Une commune compte 24 500 habitants (population moyenne). Dans l'année : 196 naissances vivantes et 270 décès. Calculez le taux brut de natalité, le taux brut de mortalité et le solde naturel. Interprétez.

Corrigé

- Natalité = 196 / 24 500 × 1 000 = **8,0 ‰**.
- Mortalité = 270 / 24 500 × 1 000 = 11,02 ≈ **11,0 ‰**.
- Solde naturel = 196 − 270 = **− 74** habitants.

Interprétation : la commune perd des habitants par le mouvement naturel (plus de décès que de naissances) ; la population est probablement âgée ; il faut le vérifier par la structure par âge avant de comparer la mortalité à celle d'autres territoires (taux standardisé).

À vous de jouer – Exercice 4 – Standardisation directe

Âge	Pop. quartier 1	Décès 1	Pop. quartier 2	Décès 2
0-39 ans	3 000	3	2 000	1
40-64 ans	1 500	12	1 500	9
65 ans ou plus	500	25	1 500	60
Total	5 000	40	5 000	70

Population de référence : 2 500 (0-39), 1 500 (40-64), 1 000 (65 et +). Calculez les taux bruts, les taux spécifiques et les taux standardisés. Conclusion ?

Corrigé

Taux bruts : Q1 = 40 / 5 000 × 1 000 = **8,0 ‰** ; Q2 = 70 / 5 000 × 1 000 = **14,0 ‰**. **Taux spécifiques (‰)** : Q1 : 3/3 000 × 1 000 = 1,0 ; 12/1 500 × 1 000 = 8,0 ; 25/500 × 1 000 = 50,0. Q2 : 1/2 000 × 1 000 = 0,5 ; 9/1 500 × 1 000 = 6,0 ; 60/1 500 × 1 000 = 40,0. **Décès attendus dans la population de référence** : Q1 = 2 500 × 1,0/1 000 + 1 500 × 8,0/1 000 + 1 000 × 50,0/1 000 = 2,5 + 12 + 50 = **64,5** ; Q2 = 2 500 × 0,5/1 000 + 1 500 × 6,0/1 000 + 1 000 × 40,0/1 000 = 1,25 + 9 + 40 = **50,25**. **Taux standardisés** : Q1 = 64,5 / 5 000 × 1 000 = **12,9 ‰** ; Q2 = 50,25 / 5 000 × 1 000 = **10,05 ≈ 10,1 ‰**. **Conclusion** : le quartier 2 a un taux brut plus élevé parce qu'il est plus âgé (30 % de 65 ans ou plus contre 10 %) ; à structure d'âge égale, c'est le **quartier 1** qui a la mortalité la plus élevée (12,9 ‰ contre 10,1 ‰) : la priorité de prévention porte sur lui.

À vous de jouer – Exercice 5 – Structure par âge

Commune de 38 000 habitants : 8 200 ont moins de 20 ans, 20 600 ont de 20 à 64 ans, 9 200 ont 65 ans ou plus. Calculez la part des 65 ans ou plus, le rapport de dépendance et l'indice de vieillissement.

Corrigé

- Part des 65 ans ou plus = 9 200 / 38 000 × 100 = **24,2 %** (France : 22,2 %).
- Rapport de dépendance = (8 200 + 9 200) / 20 600 × 100 = 17 400 / 20 600 × 100 = **84,5** personnes « dépendantes » pour 100 personnes de 20 à 64 ans.
- Indice de vieillissement = 9 200 / 8 200 × 100 = **112,2** personnes âgées pour 100 jeunes.

Interprétation : la commune est plus âgée que la moyenne nationale ; les besoins portent sur le vieillissement (dénutrition, portage de repas, lien social).

À vous de jouer – Exercice 6 – Prévalence et incidence à l'école

Au bilan de septembre, 45 enfants sur 320 sont en surpoids (obésité comprise). Au cours de l'année scolaire, 12 enfants qui n'étaient pas en surpoids en septembre le deviennent. Calculez la prévalence en septembre et l'incidence cumulée sur l'année.

Corrigé

- **Prévalence** = 45 / 320 = 0,1406, soit **14,1 %**.
- **Population à risque** = 320 − 45 = 275 enfants. **Incidence cumulée** = 12 / 275 = 0,0436, soit **4,4 %** sur l'année scolaire.
- **Interprétation** : la prévention primaire (actions pour tous) vise à réduire ces 4,4 % de nouveaux cas ; le repérage et la prise en charge précoce (prévention secondaire) visent à réduire la prévalence de 14,1 %.

À vous de jouer – Exercice 7 – Mortalité infantile

Dans un département, 1 250 naissances vivantes et 6 décès d'enfants de moins d'un an ont été enregistrés. Calculez le taux de mortalité infantile.

Corrigé

Taux = 6 / 1 250 × 1 000 = **4,8 décès pour 1 000 naissances vivantes**. Avec de si petits effectifs, ce taux varie beaucoup d'une année sur l'autre : on calcule plutôt une moyenne sur 3 à 5 ans avant de conclure.

À vous de jouer – Exercice 8 – Déterminants structurels ou intermédiaires ?

Classez : chômage ; consommation de sodas ; politique de logement ; stress lié aux fins de mois ; absence de réfrigérateur ; niveau de diplôme ; tarification de la cantine ; accès à un médecin traitant.

Corrigé

Structurels : chômage (position sociale, emploi) ; politique de logement (contexte politique) ; niveau de diplôme (position sociale) ; tarification de la cantine (politique sociale locale). **Intermédiaires** : consommation de sodas (comportement) ; stress lié aux fins de mois (facteur psychosocial) ; absence de réfrigérateur (condition matérielle) ; accès à un médecin traitant (système de santé).

À vous de jouer – Exercice 9 – Rédiger des constats à partir de données

Indicateur	Quartier des Lilas (QPV)	Commune
Taux de pauvreté	38 %	14 %
Familles monoparentales	31 %	15 %

Indicateur	Quartier des Lilas (QPV)	Commune
Part des 0-14 ans	26 %	17 %
Commerces de fruits et légumes	0	6
Restauration rapide	4	9

Rédigez trois constats pour un diagnostic.

Corrigé

1. Constat social : le quartier des Lilas cumule une forte précarité : son taux de pauvreté (38 %) est 2,7 fois celui de la commune (38 / 14 = 2,7) et les familles monoparentales y sont deux fois plus fréquentes (31 % contre 15 %).

2. Constat démographique : la population est jeune (26 % de 0-14 ans contre 17 %) : les enfants et leurs familles sont un public prioritaire.

3. Constat d'environnement alimentaire : aucun commerce de fruits et légumes, mais 4 restaurants rapides : le quartier présente les caractéristiques d'un désert et d'un « marais » alimentaires. **Conclusion** : une action sur l'accès aux fruits et légumes (marché, épicerie solidaire, paniers) et des ateliers familles sont pertinents. Chaque constat doit être **sourcé** et **daté**.

À vous de jouer – Exercice 10 – Critiquer une affirmation

« Le département X a un taux brut de mortalité de 12 ‰ contre 9 ‰ en France : la santé y est donc moins bonne. » Critiquez.

Corrigé

La conclusion est **hâtive** : le taux brut dépend de la **structure par âge** ; si le département est âgé, son taux brut est mécaniquement plus élevé. Il faut comparer des **taux standardisés** (ou l'indice comparatif de mortalité), l'**espérance de vie**, la **mortalité prématurée**, préciser l'**année** et la **source**, et vérifier la significativité de l'écart.

2.8.3 Questions de réflexion

À vous de jouer – Question 1

Pourquoi le diététicien doit-il s'intéresser aux revenus, au logement et aux transports, alors que son métier porte sur l'alimentation ?

Corrigé

Parce que ces **déterminants** conditionnent la possibilité même de suivre des conseils alimentaires : sans cuisine équipée, sans commerce accessible ou avec un budget très contraint, les recommandations restent théoriques. Les modèles de Dahlgren et Whitehead et de l'OMS montrent que les comportements alimentaires sont **déterminés** par les conditions de vie. Le diététicien adapte donc ses conseils (recettes à petit budget, sans four), oriente vers les aides, et participe à des actions sur l'environnement (cantine, épicerie solidaire), en partenariat avec les acteurs sociaux.

À vous de jouer – Question 2

Faut-il privilégier les actions ciblées sur les quartiers prioritaires ou les actions pour toute la population ?

Corrigé

Les deux, selon le principe d'**universalisme proportionné** : des actions universelles (pour éviter la stigmatisation et agir sur le gradient) dont l'intensité est renforcée dans les quartiers et pour les groupes les plus défavorisés. Une action seulement ciblée stigmatise et oublie les classes moyennes modestes ; une action seulement universelle risque d'accroître les écarts.

À vous de jouer – Question 3

Quelles sont les limites des données nationales pour construire un projet local ?

Corrigé

Elles ne décrivent pas les **spécificités** du territoire (structure par âge, pauvreté, offre alimentaire, culture), elles peuvent être **anciennes** (ESTEBAN date de 2015) et elles ne disent rien des **besoins exprimés** par les habitants. Elles servent de **référence de comparaison** et de **justification** (le problème existe à l'échelle nationale), mais le diagnostic doit s'appuyer sur des données locales (Insee, ORS, santé scolaire) et sur le recueil des besoins.

2.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – La communauté de communes du Val-Vert (rurale, 18 000 habitants)

Données : 27 % de 65 ans ou plus (France : 22,2 %) ; taux de pauvreté 17 % ; 2 supermarchés pour 14 communes ; transport à la demande deux jours par semaine ; indice comparatif de mortalité prématurée (ORS) de 118 ; 3 diététiciens libéraux sur le territoire ; un contrat local de santé en préparation.

1. Interprétez l'indice comparatif de mortalité prématurée de 118.
2. Identifiez les déterminants (au moins un par couche de Dahlgren et Whitehead) des difficultés alimentaires des personnes âgées.
3. Quelles données complémentaires rechercheriez-vous, et où ?
4. Proposez deux priorités et justifiez-les.
5. Montrez comment appliquer l'universalisme proportionné.

Corrigé

1. Un ICM de 118 signifie qu'à **structure d'âge égale**, la mortalité avant 65 ans est **supérieure de 18 %** à la moyenne nationale (référence = 100). Il faudrait vérifier son intervalle de confiance (significativité) et les causes (cancers, maladies cardiovasculaires, alcool, accidents).
2. Âge avancé et maladies chroniques (individuels) ; alimentation monotone, faible activité (style de vie) ; isolement des personnes âgées, veuvage (réseaux) ; éloignement des commerces, transport limité, logement (conditions de vie) ; vieillissement rural, désertification commerciale, montant des retraites (conditions générales).
3. Données Insee par commune (personnes vivant seules, revenus), Assurance maladie (ALD, personnes traitées pour un diabète), données du portage de repas (CCAS, intercommunalité), données de l'ORS (causes de mortalité prématurée), entretiens avec les aides à domicile, la MSP, les clubs d'aînés ; questionnaire auprès des personnes âgées.

4. Priorité 1 : prévention de la dénutrition des personnes âgées isolées (fréquence, gravité, PNNS 5). **Priorité 2** : accès à une alimentation de qualité (transport, commerces itinérants, portage) : déterminant structurant pour toute la population rurale.

5. Actions pour tous (ateliers « bien manger après 60 ans » dans chaque commune, information) avec une intensité renforcée pour les plus vulnérables (portage de repas à tarif social, visites à domicile, transport gratuit vers le marché pour les bénéficiaires de minima sociaux).

2.8.5 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Votre tutrice vous demande où trouver le taux de pauvreté du quartier prioritaire.

Corrigé

Sur le site de l'Insee (statistiques locales, données Filosofi à l'échelle des QPV) et sur le système d'information géographique de la politique de la ville (*sig.ville.gouv.fr*) ; je note l'année des données et la comparaison avec la commune.

Mise en situation – MSE 2

Un élu dit : « Il y a plus de décès dans notre commune qu'à côté, notre population est en moins bonne santé. »

Corrigé

Je lui explique qu'il faut comparer des **taux standardisés sur l'âge** (ou l'indice comparatif de mortalité de l'ORS), car une commune plus âgée a plus de décès sans pour autant être en moins bonne santé.

Mise en situation – MSE 3

Le jury : « Qu'est-ce qu'un déterminant intermédiaire ? Donnez un exemple tiré de votre projet. »

Corrigé

Un déterminant par lequel la position sociale agit sur la santé : conditions matérielles, facteurs psychosociaux, comportements, système de santé (OMS, 2008). Exemple : l'absence de commerce de fruits et légumes dans le quartier (condition matérielle) ou la consommation de boissons sucrées (comportement).

Mise en situation – MSE 4

Une animatrice parle des familles « qui ne font pas d'efforts pour manger correctement ».

Corrigé

Je rappelle avec tact que les choix alimentaires dépendent de **contraintes** (budget, temps, équipement, offre) et je propose de les explorer avec les familles ; c'est la base d'une approche non culpabilisante et efficace.

Mise en situation – MSE 5

Quelle différence entre espérance de vie et espérance de vie sans incapacité ?

Corrigé

L'espérance de vie mesure la durée de vie moyenne (85,9 ans pour les femmes en 2025) ; l'EVSI mesure les années vécues **sans limitation** dans les activités quotidiennes (11,8 ans à 65 ans pour les femmes en 2024). L'écart correspond aux années vécues avec des incapacités : la prévention vise à le réduire.

Mise en situation – MSE 6

Un collègue confond prévalence et incidence dans un rapport.

Corrigé

Prévalence = cas existants à un moment (photographie) ; incidence = nouveaux cas pendant une période, rapportés à la population à risque (film). Je corrige les formulations et les dénominateurs.

Mise en situation – MSE 7

Votre structure veut comparer l'obésité dans deux écoles à partir de « 12 enfants » dans l'une et « 25 enfants » dans l'autre.

Corrigé

Des effectifs ne se comparent pas : il faut des **proportions** (12 / 180 = 6,7 % ; 25 / 420 = 6,0 %, par exemple), en vérifiant que la mesure est la même (même âge, même méthode).

Mise en situation – MSE 8

Qu'apporte une pyramide des âges à votre diagnostic ?

Corrigé

Elle montre la structure par âge, donc les publics prioritaires (jeunes familles ou personnes âgées), les évolutions prévisibles (vieillissement des baby-boomers) et elle aide à interpréter les taux bruts.

Mise en situation – MSE 9

On vous demande un indicateur d'inégalité sociale pour votre projet.

Corrigé

Par exemple, la participation aux ateliers selon le quartier de résidence (QPV ou non) ou selon que la famille est suivie par l'épicerie solidaire, ou l'évolution des résultats selon le niveau de revenu déclaré (en classes, avec accord et anonymat).

Mise en situation – MSE 10

Pourquoi parle-t-on de « 1000 premiers jours » ?

Corrigé

Parce que la période allant de la conception aux 2 ans de l'enfant est déterminante pour la santé future (approche parcours de vie) ; les inégalités s'y construisent tôt ; d'où le programme « 1000 premiers jours » (2020) et la priorité donnée à la petite enfance dans le PNNS 5.

Mise en situation – MSE 11

Un financeur demande la source d'un chiffre de votre dossier.

Corrigé

Chaque chiffre doit être accompagné de l'**organisme**, du **titre** du document, de l'**année** des données et du **lien** (bibliographie numérotée) : par exemple « Insee, Bilan démographique 2025, Insee Première n° 2087, janvier 2026 ».

Mise en situation – MSE 12

Pourquoi l'outre-mer est-il souvent cité dans le PNNS 5 ?

Corrigé

Parce que les inégalités territoriales y sont fortes : mortalité standardisée nettement supérieure (+ 89 % à Mayotte, + 37 % en Guyane en 2023), prévalence de l'obésité plus élevée (22,4 % contre 17,9 % dans l'Hexagone), prix alimentaires plus élevés ; le PNNS 5 prévoit des actions spécifiques pour ces territoires.

2.8.6 Exercices complémentaires

À vous de jouer – Exercice 11 – IMC et prévalences

Dans un club de seniors, 80 adhérents ont été pesés et mesurés : 3 ont un IMC < 18,5 ; 30 entre 18,5 et 24,9 ; 31 entre 25 et 29,9 ; 16 ≥ 30. Calculez les prévalences de chaque classe et du surpoids obésité comprise. Quelle limite pour les personnes âgées ?

Corrigé

Maigreur : 3 / 80 = **3,75 %** ; normal : 30 / 80 = **37,5 %** ; surpoids : 31 / 80 = **38,75 %** ; obésité : 16 / 80 = **20,0 %** ; surpoids obésité comprise : 47 / 80 = **58,75 %**. Vérification : 3 + 30 + 31 + 16 = 80 . ✓**Limite** : chez la personne âgée, l'IMC reflète mal la composition corporelle (perte de muscle, sarcopénie) ; la HAS (2021) retient pour la dénutrition un **IMC < 22** chez les 70 ans et plus, et non 18,5 : un IMC « normal » peut masquer une dénutrition.

À vous de jouer – Exercice 12 – Écart en points et écart relatif

La prévalence du surpoids des enfants est de 18 % dans une école et de 12 % dans la commune. Exprimez l'écart en points et en pourcentage.

Corrigé

Écart en points : 18 − 12 = **6 points**. Écart relatif : 6 / 12 × 100 = **50 %** : le surpoids est 1,5 fois plus fréquent dans l'école (18 / 12 = 1,5). Attention : dire « 6 % de plus » serait ambigu.

À vous de jouer – Exercice 13 – Construire un indicateur de précarité alimentaire

Lors d'un questionnaire de quartier (n = 150), 39 personnes répondent « souvent » ou « parfois » à la question « Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de ne pas avoir assez à manger ? ». Calculez la proportion et comparez-la au chiffre national.

Corrigé

Proportion = 39 / 150 = **26,0 %**, contre 16 % en France (Crédoc, 2022) : 10 points de plus, soit 1,6 fois plus (26 / 16 = 1,63). La comparaison est possible si la question est **identique** à celle de l'enquête nationale ; l'échantillon de 150 personnes donne un ordre de grandeur, pas une valeur précise.

À vous de jouer – Exercice 14 – Lire un tableau de causes de décès

Sur 641 046 décès en 2024, les tumeurs représentent 27,1 % et les maladies cardio-neurovasculaires 21,2 %. Calculez le nombre approximatif de décès dus à chacune de ces causes.

Corrigé

Tumeurs : 641 046 × 0,271 = 173 723, soit **environ 174 000 décès** (173 502 exactement). Maladies cardio-neurovasculaires : 641 046 × 0,212 = 135 902, soit **environ 136 000 décès**. Ensemble : environ 310 000 décès, soit près de la moitié des décès (48,3 %).

À vous de jouer – Exercice 15 – Choisir des indicateurs pour un diagnostic

Vous préparez un projet de prévention de la dénutrition dans une commune. Proposez 6 indicateurs (2 démographiques, 2 sociaux, 2 de santé) et leur source.

Corrigé

Démographiques : part des 75 ans ou plus (Insee) ; part des personnes de 80 ans ou plus vivant seules (Insee). Sociaux : part des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du minimum vieillesse (caisses de retraite, département) ; nombre de bénéficiaires du portage de repas (CCAS). Santé : nombre de personnes âgées hospitalisées pour dénutrition ou chute (PMSI, ARS, ORS) ; prévalence de la dénutrition chez les bénéficiaires du portage repérée par une pesée (enquête locale).

2.8.7 Exercices de synthèse

À vous de jouer – Exercice 16 – Schéma à légender : la transition démographique

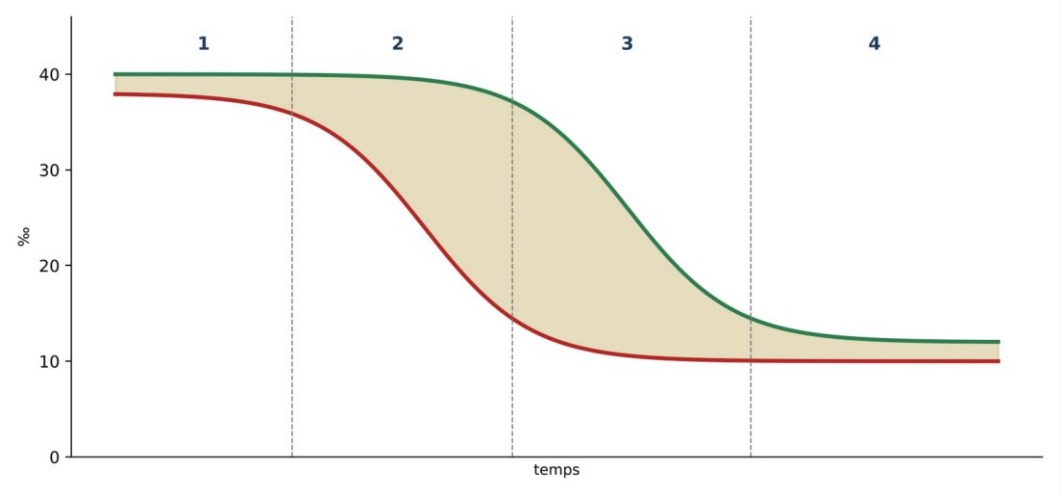


Figure 2.12 – Schéma à légender

Nommez les phases 1 à 4, identifiez les deux courbes et la zone colorée, puis situez la France actuelle.

Corrigé

1. Régime ancien (natalité et mortalité élevées). 2. **Baisse de la mortalité** (accroissement naturel maximal). **3. Baisse de la natalité**. 4. **Régime moderne** (taux bas, vieillissement). Courbe du haut : **natalité** ; courbe du bas : **mortalité** ; zone colorée : **accroissement naturel**. La France est en **phase 4**, avec un accroissement naturel devenu quasi nul.

À vous de jouer – Exercice 17 – Schéma à légender : le tableau 2 × 2

	Malades (surpoids)	Non malades	Total
Exposés (boisson sucrée quotidienne)	?	?	200
Non exposés	?	?	300
Total	66	434	500

Figure 2.13 – Tableau à compléter

Dans une enquête, 66 des 500 enfants sont en surpoids ; 200 enfants sont exposés (boisson sucrée quotidienne) ; le risque chez les exposés est de 18 %. Complétez les cases a, b, c, d, puis calculez le RR.

Corrigé

a = 0,18 × 200 = **36** ; b = 200 − 36 = **164** ; c = 66 − 36 = **30** ; d = 300 − 30 = **270** (non-exposés : 500 − 200 = 300). R0 = 30 / 300 = 0,10 ; RR = 0,18 / 0,10 = **1,8**.

À vous de jouer – Exercice 18 – Indicateurs de vieillissement

Un EPCI compte 31 500 habitants : 5 670 de moins de 20 ans, 17 010 de 20 à 64 ans, 8 820 de 65 ans ou plus. Calculez la part des 65 ans ou plus, l'indice de vieillissement et le rapport de dépendance des âgés. Quel

public prioriser ?

Corrigé

Vérification : 5 670 + 17 010 + 8 820 = **31 500** . Part des 65 ans ou plus : 8 820 / 31 500 × 100 = **28,0 %**. Indice de ✓ vieillissement : 8 820 / 5 670 × 100 = **155,6**. Rapport de dépendance des âgés : 8 820 / 17 010 × 100 = **51,9** (52 seniors pour 100 personnes de 20 à 64 ans). Public prioritaire : personnes âgées (prévention de la dénutrition, maintien de l'autonomie, lien social autour du repas).

À vous de jouer – Exercice 19 – Fraction attribuable

Dans une population de 2 000 adultes, 30 % sont sédentaires ; le risque de diabète de type 2 est de 9 % chez les sédentaires et de 5 % chez les autres. Calculez le RR, la fraction attribuable chez les exposés, dans la population, et le nombre de cas attribuables.

Corrigé

RR = 9 / 5 = **1,8**. Fraction chez les exposés : (1,8 − 1) / 1,8 = **0,444**. Fraction dans la population : pe = 0,30 ; 0,30 × 0,8 = 0,24 ; 0,24 / 1,24 = **0,194**. Cas totaux : sédentaires 600 × 0,09 = 54 ; autres 1 400 × 0,05 = 70 ; total **124**. Cas attribuables : 124 × 0,194 = **24 cas** (vérification : 54 − 600 × 0,05 = 54 − 30 = **24**). Si la relation est causale, ✓ supprimer la sédentarité éviterait environ 24 cas sur 124.

À vous de jouer – Exercice 20 – Écart absolu, écart relatif

La prévalence de l'obésité est de 8 % chez les adultes du premier quintile de revenu et de 4 % chez ceux du dernier ; dix ans plus tard, 12 % et 7 %. L'inégalité a-t-elle augmenté ?

Corrigé

Avant : écart absolu 8 − 4 = **4 points**, rapport 8 / 4 = **2,0**. Après : 12 − 7 = **5 points**, rapport 12 / 7 = **1,71**. L'écart **absolu augmente** (+ 1 point) tandis que l'écart **relatif diminue** : la réponse dépend de la mesure ; on présente les deux. En santé publique, l'écart absolu traduit le nombre de personnes supplémentaires touchées et reste un indicateur prioritaire.

À vous de jouer – Exercice 21 – Taux pour 100 000 et regroupement d'années

Une commune de 8 400 habitants a enregistré 6, 11 et 7 décès par cancer colorectal en trois ans. Calculez le taux annuel pour chacune des années puis le taux annuel moyen ; commentez.

Corrigé

Année 1 : 6 / 8 400 × 100 000 = **71,4** ; année 2 : 11 / 8 400 × 100 000 = **131,0** ; année 3 : 7 / 8 400 × 100 000 = **83,3** pour 100 000. Moyenne : (6 + 11 + 7) / (8 400 × 3) × 100 000 = 24 / 25 200 × 100 000 = **95,2 pour 100 000**. Les taux annuels varient presque du simple au double par le seul effet du hasard (petits nombres) : on utilise le taux moyen sur 3 ans, standardisé sur l'âge pour comparer.

À vous de jouer – Exercice 22 – Commenter un graphique

Rédigez le commentaire en 5 phrases de la figure 2.11 (surpoids et obésité selon le milieu social en grande section).

Corrigé

1. « Ce graphique présente la prévalence du surpoids et de l'obésité des enfants de grande section selon la profession de leurs parents (DREES, 2012-2013). » 2. « Les deux indicateurs augmentent quand on descend dans l'échelle sociale. » 3. « L'obésité concerne 1,3 % des enfants de cadres contre 5,8 % des enfants d'ouvriers. » 4. « Elle est donc 4,5 fois plus fréquente chez les enfants d'ouvriers (+ 4,5 points) ; pour le surpoids, 16 % contre 7 %, soit 2,3 fois plus. » 5. « Ces inégalités, présentes dès 5-6 ans, reflètent des conditions de vie précoces différentes et justifient d'agir tôt, auprès des familles et dans les écoles des quartiers défavorisés, selon l'universalisme proportionné ; les données datent de 2012-2013 et doivent être actualisées. »

2.8.8 Deuxième étude de cas

Mise en situation – Étude de cas 2 – La ville de Port-Clair et la précarité alimentaire

Port-Clair (52 000 habitants, données fictives) veut définir sa politique alimentaire. Données : 3 quartiers prioritaires (11 800 habitants) ; taux de pauvreté 19 % (ville) et 43 % (QPV) ; 3 épiceries solidaires (640 foyers inscrits) ; bilan de grande section : 13 % de surpoids (QPV) contre 8 % (hors QPV) sur 610 enfants examinés, dont 180 en QPV ; mortalité cardio-neurovasculaire : 312 décès en 3 ans ; enquête téléphonique auprès de 400 habitants : 22 % déclarent avoir « parfois ou souvent » manqué de nourriture dans l'année.

1. Calculez la part de la population vivant en QPV, le nombre d'enfants en surpoids dans et hors QPV, l'écart absolu et relatif.
2. Calculez le taux annuel moyen de mortalité cardio-neurovasculaire pour 100 000 ; que faut-il pour le comparer à la France ?
3. Calculez la marge d'erreur du résultat de l'enquête téléphonique et commentez les biais possibles.
4. Identifiez les déterminants en jeu (Dahlgren et Whitehead) et proposez trois actions selon l'universalisme proportionné.
5. Quels indicateurs suivre sur 5 ans ?

Corrigé

1. QPV : 11 800 / 52 000 × 100 = **22,7 %**. Enfants : QPV 0,13 × 180 = **23,4**, soit environ **23** ; hors QPV : 610 − 180 = 430 ; 0,08 × 430 = **34,4**, soit environ **34**. Écart absolu : 13 − 8 = **5 points** ; relatif : 13 / 8 = **1,63**.
2. Taux annuel moyen : 312 / (52 000 × 3) × 100 000 = 312 / 156 000 × 100 000 = **200 pour 100 000**. Pour comparer : taux **standardisé** sur l'âge (ou ICM) et intervalle de confiance.
3. p = 0,22 ; 0,22 × 0,78 = 0,1716 ; / 400 = 0,000429 ; √ = 0,0207 ; × 1,96 = **0,041**, soit **± 4,1 points** (IC 17,9 % – 26,1 %). Biais : personnes sans téléphone fixe ou ne répondant pas (souvent les plus précaires : sous-estimation probable), désirabilité sociale (honte à déclarer), question rétrospective sur un an (mémoire).
4. Déterminants : conditions de vie (revenus, emploi, logement), environnement alimentaire (offre, prix), réseaux sociaux et communautaires, comportements individuels. Actions : **universelles** (repas scolaires de qualité et tarification sociale pour toutes les écoles, campagne « eau du robinet ») ; **renforcées** en QPV (ateliers culinaires, chèques fruits et légumes, épiceries solidaires, jardins partagés) ; **structurelles** (plaidoyer pour un marché de plein vent en QPV, PAT).
5. Prévalence du surpoids en grande section par secteur ; part de foyers en insécurité alimentaire (même méthode d'enquête) ; fréquentation des épiceries solidaires ; part de produits durables en restauration scolaire ; participation aux ateliers par quartier ; mortalité cardio-neurovasculaire standardisée (tendance à long terme).

2.8.9 Mises en situation express complémentaires

Mise en situation – MSE 13

Le jury : « Qu'est-ce que la transition nutritionnelle ? »

Corrigé

C'est l'évolution des régimes alimentaires avec le développement économique : plus de produits animaux, de sucres, de graisses et d'aliments transformés, moins d'activité physique, ce qui entraîne une hausse du surpoids et des maladies chroniques (Popkin).

Mise en situation – MSE 14

Une collègue écrit dans un rapport : « Le surpoids est 5 % plus élevé dans le quartier (14 % contre 9 %). »

Corrigé

Je corrige : c'est 5 **points** de plus, soit une prévalence 1,56 fois plus élevée (+ 56 % en relatif).

Mise en situation – MSE 15

Le jury : « Votre enquête montre que les enfants qui boivent des sodas sont plus souvent en surpoids : les sodas en sont-ils la cause ? »

Corrigé

Mon enquête transversale montre une association (RR de 1,8) mais pas une causalité : des facteurs de confusion comme le revenu, le sommeil ou les écrans peuvent jouer. La causalité est établie par l'ensemble des études, notamment les cohortes et les essais, ce qui justifie le repère de limitation des boissons sucrées.

Mise en situation – MSE 16

Le jury : « Pourquoi parlez-vous d'AVCI plutôt que de mortalité ? »

Corrigé

Parce que beaucoup de maladies liées à la nutrition tuent peu mais dégradent la qualité de vie pendant des années (diabète, arthrose liée à l'obésité) ; les AVCI additionnent décès prématurés et années vécues avec incapacité.

Mise en situation – MSE 17

Le maire vous demande « le chiffre de l'insécurité alimentaire dans la commune ».

Corrigé

J'explique qu'il n'existe pas de donnée communale officielle ; je donne les références nationales (11 % des adultes, INCA 3 ; 16 % déclarant ne pas toujours avoir assez à manger, Crédoc 2022), les données des épiceries solidaires et du CCAS, et je propose une enquête locale avec un questionnaire validé.

Mise en situation – MSE 18

Le jury : « Votre territoire est-il plus âgé que la moyenne ? Comment le montrez-vous ? »

Corrigé

Avec la part des 65 ans ou plus et l'indice de vieillissement comparés à la France et au département, à la même date, à partir des données de l'Insee ; j'en déduis le public prioritaire.

2.9 Glossaire

Terme	Définition
Affection de longue durée (ALD)	Maladie chronique nécessitant un traitement prolongé, prise en charge à 100 % par l'Assurance maladie
AVCI (DALY)	Années de vie corrigées de l'incapacité : années perdues par décès prématuré + années vécues avec une incapacité
Déterminant de santé	Facteur qui influence l'état de santé (individuel, social, économique, environnemental, politique)
Déterminants structurels / intermédiaires	Structurels : contexte socio-politique et position sociale ; intermédiaires : conditions matérielles, facteurs psychosociaux, comportements, système de santé (OMS, 2008)
Désert alimentaire	Zone où l'accès physique à des aliments frais et variés est difficile
Environnement alimentaire	Conditions qui déterminent la disponibilité, l'accessibilité, l'attractivité et la qualité des aliments
Espérance de vie à la naissance	Durée de vie moyenne d'une génération fictive soumise aux taux de mortalité par âge de l'année
EVSI	Espérance de vie sans incapacité (années de vie sans limitation d'activité)
Gradient social	Amélioration progressive de l'état de santé à chaque échelon de l'échelle sociale
ICF	Indicateur conjoncturel de fécondité : nombre moyen d'enfants par femme
Incidence	Nouveaux cas pendant une période / population à risque
Indice comparatif de mortalité (ICM)	Décès observés / décès attendus × 100 (standardisation indirecte)
Inégalités sociales de santé	Différences de santé systématiques, évitables et injustes entre groupes sociaux
Marais alimentaire	Zone saturée d'offre de restauration rapide et d'aliments peu favorables à la santé
Mortalité évitable	Décès avant 75 ans qui auraient pu être évités par la prévention ou les soins
Mortalité prématurée	Décès survenant avant 65 ans
Précarité alimentaire	Difficulté d'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de qualité et en quantité suffisante (art. L. 266-1 CASF)
Prévalence	Cas existants / population à un moment donné
Pyramide des âges	Représentation graphique de la population par âge et par sexe
Rapport de dépendance	(Moins de 20 ans + 65 ans ou plus) / 20-64 ans × 100

Terme	Définition
Solde naturel	Naissances – décès
Taux brut	Nombre d'événements / population totale × 1 000
Taux spécifique	Taux calculé dans un sous-groupe (âge, sexe, cause)
Taux standardisé	Taux calculé en appliquant les taux spécifiques à une population de référence commune
Biais écologique	Erreur consistant à attribuer aux individus une relation observée entre territoires
Double fardeau de la malnutrition	Coexistence de dénutrition (ou carences) et de surpoids dans une population ou un foyer
Exposome	Ensemble des expositions d'un individu de la conception à la mort
Facteur de confusion	Facteur lié à l'exposition et au problème, pouvant fausser une association
Fraction attribuable	Part des cas attribuables à une exposition (si la relation est causale)
Indice de vieillissement	65 ans ou plus / moins de 20 ans × 100
Insécurité alimentaire	Accès limité ou incertain à une alimentation suffisante, saine et acceptable
Rapport de cotes (odds ratio)	(a × d) / (b × c) ; proche du RR pour une maladie rare
Rapport de dépendance	(moins de 20 ans + 65 ans ou plus) / 20-64 ans × 100
Risque relatif	Risque chez les exposés / risque chez les non-exposés
Transition démographique	Passage de taux de natalité et de mortalité élevés à des taux bas
Transition épidémiologique	Passage des maladies infectieuses aux maladies chroniques comme causes principales de décès
Transition nutritionnelle	Évolution des régimes vers plus de produits animaux, sucres, graisses et aliments transformés

2.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Modèles de déterminants	[1] Lalonde ; [2] Dahlgren et Whitehead ; [3] Solar et Irwin, OMS ; [4] Commission OMS 2008
Inégalités sociales de santé	[4] OMS 2008 ; [5] Marmot 2010 ; [6] Insee 2018 ; [12] HCSP ; [14] Darmon
Démographie	[7] Insee, Bilan démographique 2025 ; [8] Drees, EVSI
Mortalité et causes de décès	[9] Drees, Inserm-CépiDc, Santé publique France 2026 ; [15] Bonita et coll.
Données nutritionnelles et sociales	[10] OFÉO 2024 ; [11] Crédoc ; [12] HCSP 2025 ; [13] Baromètre Santé publique France 2024
Sources de données locales	[7] Insee ; [16] Géodes ; [17] Score-santé ; [18] data.ameli

2.12 Bibliographie numérotée

1. Lalonde M. *Nouvelle perspective de la santé des Canadiens*. Ottawa, Gouvernement du Canada, 1974.

2. Dahlgren G., Whitehead M. *Policies and strategies to promote social equity in health*. Stockholm, Institute for Futures Studies, 1991.

3. Solar O., Irwin A. *A conceptual framework for action on the social determinants of health*. Genève, OMS, 2010.

4. Commission des déterminants sociaux de la santé. *Combler le fossé en une génération*. Genève, OMS, 2008.

5. Marmot M. et coll. *Fair Society, Healthy Lives (The Marmot Review)*. Londres, 2010.

6. Blanpain N. « L'espérance de vie par niveau de vie : chez les hommes, 13 ans d'écart entre les plus aisés et les plus modestes ». *Insee Première*, n° 1687, février 2018.

7. Insee. *Bilan démographique 2025*. Insee Première n° 2087, janvier 2026. insee.fr

8. Drees. « L'espérance de vie sans incapacité à 65 ans est de 11,8 ans pour les femmes et de 10,5 ans pour les hommes en 2024 ». *Études et résultats* n° 1363, 22 janvier 2026.

9. Drees, Inserm-CépiDc. « Nouvelle baisse de la mortalité en 2024 malgré une hausse des maladies respiratoires » (causes de décès 2024). *Études et résultats* n° 1375, juin 2026 ; Fouillet A. et coll. « Grandes causes de mortalité et principales causes associées ». *BEH*, 2026, n° 15, p. 326-352.

10. Ligue nationale contre l'obésité. *Étude OFÉO*. Juin 2024.

11. Crédoc. *En forte hausse, la précarité alimentaire s'ajoute à d'autres fragilités*. 2023.

12. Haut Conseil de la santé publique. *Recommandations pour l'élaboration du 5e PNNS*. Juin 2025.

13. Santé publique France. *Activité physique : pratiques et connaissance de la recommandation. Baromètre de Santé publique France : résultats de l'édition 2024*. Décembre 2024.

14. Darmon N., Drewnowski A. « Contribution of food prices and diet cost to socioeconomic disparities in diet quality and health ». *Nutrition Reviews*, 2015, 73 (10), p. 643-660.

15. Bonita R., Beaglehole R., Kjellström T. *Éléments d'épidémiologie*. 2e éd., OMS, 2010.

16. Santé publique France. Géodes, observatoire cartographique. geodes.santepubliquefrance.fr

17. FNORS. Score-santé. scoresante.org

18. Assurance maladie. Data pathologies. data.ameli.fr

19. Rey G. et coll. « Ecological association between a deprivation index and mortality in France over the period 1997-2001 ». *BMC Public Health*, 2009, 9:33.

20. Code de l'action sociale et des familles, article L. 266-1 (lutte contre la précarité alimentaire), issu de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018.

21. Omran A. R. « The epidemiologic transition: a theory of the epidemiology of population change ». *Milbank Memorial Fund Quarterly*, 1971, 49 (4), p. 509-538.

22. Popkin B. M. « Nutritional patterns and transitions ». *Population and Development Review*, 1993, 19 (1), p. 138- 157.

23. Insee. *Bilan démographique* (2024 et 2025). Insee Première, janvier de chaque année.

24. GBD 2017 Diet Collaborators. « Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990-2017 ». *The Lancet*, 2019, 393, p. 1958-1972.

25. Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). *Les cancers attribuables au mode de vie et à l'environnement en France métropolitaine*. Lyon, 2018.

26. Institut national du cancer (INCa). *Panorama des cancers en France*. Édition 2024.

27. DREES. « La santé des élèves de grande section de maternelle en 2013 : des inégalités sociales dès le plus jeune âge ». *Études et Résultats*, n° 920, juin 2015.

28. Crédoc. *Baromètre de la précarité et de l'alimentation*. 2023.

29. IGAS. *La lutte contre la précarité alimentaire*. Rapport, 2019.

30. HAS, FFN. *Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus*. Recommandation, novembre 2021.

31. FAO. *Food Insecurity Experience Scale (FIES)*. Rome.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 2.2.2)

32. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

33. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE

CHAPITRE

02

Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé

Déterminants de santé | Inégalités | Mesure de l'état de santé

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

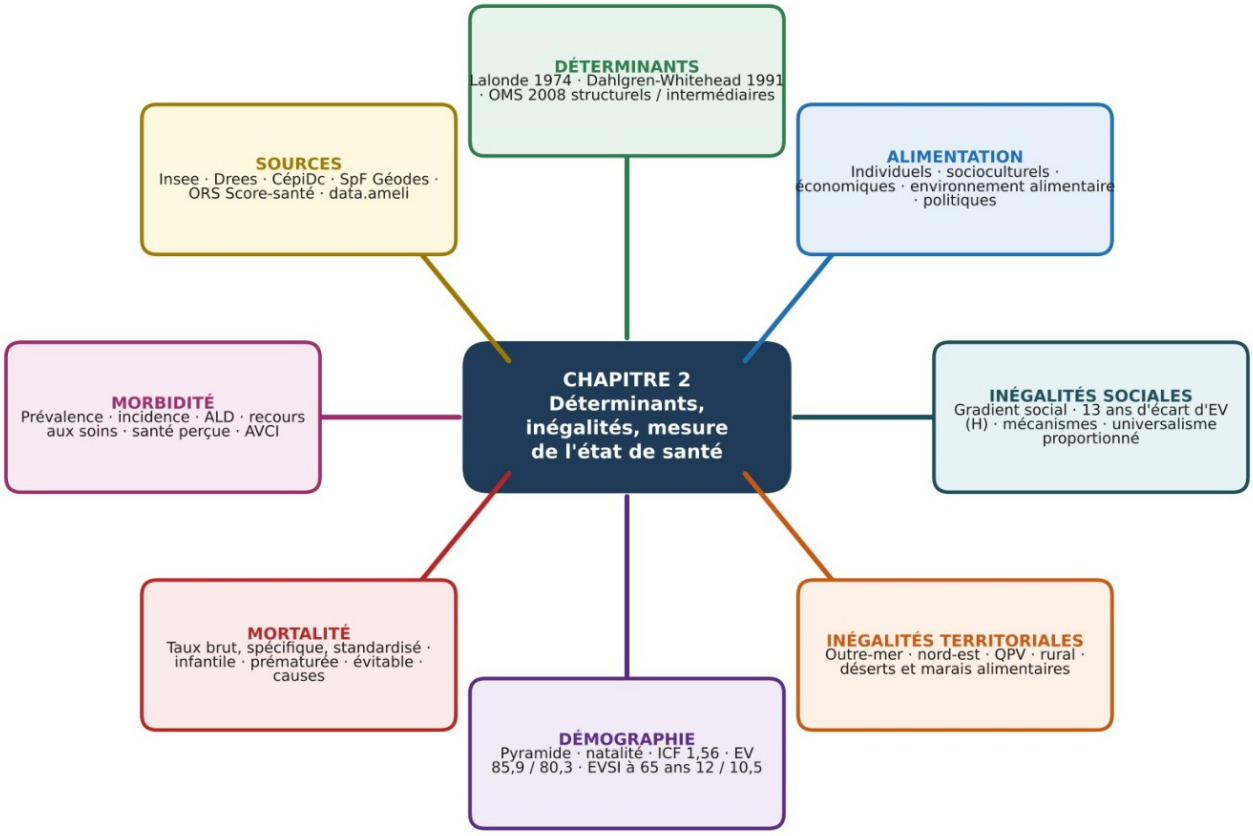
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 2 102
1. Les définitions à savoir 102
2. Les trois modèles de déterminants 103
3. Les formules 103
4. Chiffres-clés 103
5. Les pièges 103
6. Méthode express : portrait de territoire en 6 étapes 104
7. Auto-test 104
8. Flashcards 104
Compléments du chapitre enrichi 104

Fiches-outils du chapitre 2 105
O2.1 – Grille des déterminants de l'alimentation de mon public 105
O2.2 – Tableau d'indicateurs comparés 105
O2.3 – Calcul d'un taux standardisé (méthode directe) 105
O2.4 – Repérer les inégalités dans mon projet 106
O2.5 – Grille de lecture critique d'un indicateur 106

Fiche de révision du chapitre 2

Déterminants de santé, inégalités sociales et territoriales, mesure de l'état de santé



Carte mentale du chapitre 2

1. Les définitions à savoir

Notion	Définition	Source
Déterminant de santé	Facteur personnel, social, économique, environnemental ou politique qui influence l'état de santé	OMS, 1998
Inégalités sociales de santé	Différences de santé systématiques, socialement produites, évitables et injustes	OMS 2008
Gradient social	La santé s'améliore à chaque échelon de l'échelle sociale	Marmot
Environnement alimentaire	Conditions de disponibilité, accessibilité, attractivité et qualité des aliments	–
Précarité alimentaire	Difficulté d'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de qualité et suffisante	Art. L. 266-1 CASF
Espérance de vie	Durée de vie moyenne d'une génération fictive soumise aux taux de mortalité de l'année	Insee
EVSI	Années de vie sans limitation d'activité	Drees
Prévalence / incidence	Cas existants à un instant / nouveaux cas sur une période rapportés à la population à risque	–

2. Les trois modèles de déterminants

Modèle	Contenu
Lalonde (1974)	Biologie humaine – environnement – habitudes de vie – organisation des soins
Dahlgren et Whitehead (1991)	5 couches : individu ; style de vie ; réseaux ; conditions de vie et de travail ; conditions générales
OMS (2008, Solar et Irwin 2010)	Structurels (contexte, position sociale) → intermédiaires (matériels, psychosociaux, comportements, système de santé) → équité

3. Les formules

Indicateur	Formule
Taux brut de natalité / mortalité	Naissances (ou décès) / population moyenne × 1 000
Taux spécifique	Décès du groupe / population du groupe × 1 000
Taux standardisé direct	(taux spécifique × pop. de référence du groupe) / pop. de référence totale Σ
Mortalité infantile	Décès < 1 an / naissances vivantes × 1 000
Rapport de dépendance	(< 20 ans + ≥ 65 ans) / (20-64 ans) × 100
Indice de vieillissement	≥ 65 ans / < 20 ans × 100
Prévalence	Cas existants / population
Incidence cumulée	Nouveaux cas / population à risque au début
Écart en points / écart relatif	A − B / (A − B) / B × 100

4. Chiffres-clés

- 69,1 millions d'habitants (1er janvier 2026) ; 22,2 % de 65 ans ou plus ; ICF 1,56 ; solde naturel − 6 000 en 2025 (Insee).
- Espérance de vie 2025 : 85,9 ans (F), 80,3 ans (H) ; EVSI à 65 ans (2024) : 11,8 ans (F), 10,5 ans (H).
- 641 046 décès en 2024 : tumeurs 27,1 %, maladies cardio-neurovasculaires 21,2 %.
- ≈ 13 ans (H) et 8 ans (F) d'écart d'espérance de vie entre les 5 % les plus aisés et les plus modestes (Insee, 2018).
- Obésité 18,1 % ; 24,7 % en cas de difficultés économiques ; 22,4 % en outre-mer (OFÉO, 2024). Précarité alimentaire 16 % (Crédoc, 2022).

5. Les pièges

Attention

- Comparer deux territoires avec des **taux bruts** → utiliser des taux **standardisés**.
- Confondre **effectif**, **proportion** et **taux**.
- Oublier d'exclure les malades du dénominateur de l'**incidence**.
- Confondre écart **en points** et écart **relatif**.
- Croire que les inégalités ne concernent que les plus pauvres (oubli du **gradient**).
- Présenter une donnée sans **année** ni **source**.

6. Méthode express : portrait de territoire en 6 étapes

1. Délimiter le territoire et le public. 2. Démographie (Insee). 3. Situation sociale (Insee, QPV). 4. État de santé (ORS, Géodes, Assurance maladie, santé scolaire). 5. Déterminants et ressources (observation, entretiens). 6. Comparer, dater, sourcer, rédiger 3 à 5 constats.

7. Auto-test

1. Citez les 4 champs de Lalonde. 2. Donnez un déterminant structurel et un intermédiaire. 3. Qu'est-ce que le gradient social ? 4. Écart d'espérance de vie entre hommes aisés et modestes ? 5. Formule du taux de mortalité infantile ? 6. Pourquoi standardiser ? 7. ICF en 2025 ? 8. Première cause de décès ? 9. Une commune : 200 décès, 25 000 habitants : taux brut ? 10. Prévalence 45/320 ? 11. Définition d'un marais alimentaire ? 12. Quelle loi définit la lutte contre la précarité alimentaire ? *Réponses : 1. Biologie, environnement, habitudes de vie, organisation des soins – 2. Revenu / consommation de sodas – 3. Santé meilleure à chaque échelon social – 4. ≈ 13 ans – 5. Décès < 1 an / naissances vivantes × 1 000 – 6. Pour éliminer l'effet de la structure par âge – 7. 1,56 – 8. Tumeurs (27 %) – 9. 200 / 25 000 × 1 000 = 8,0 ‰ – 10. 14,1 % – 11. Zone saturée d'offre peu favorable (restauration rapide) – 12. Loi EGalim (art. L. 266-1 CASF).*

8. Flashcards

Recto : Déterminants structurels selon l'OMS ?	Verso : Contexte socio-économique et politique + position sociale (éducation, profession, revenu, genre, origine)
Recto : Taux standardisé direct : principe ?	Verso : Appliquer les taux par âge de chaque population à une même population de référence
Recto : EVSI à 65 ans (2024) ?	Verso : 11,8 ans (femmes) ; 10,5 ans (hommes)
Recto : Prévalence = ?	Verso : ≈ incidence × durée (situation stable)
Recto : Désert vs marais alimentaire ?	Verso : Manque d'accès aux aliments frais / excès d'offre peu favorable
Recto : Causes de décès 2024 ?	Verso : Tumeurs 27,1 % ; cardio-neurovasculaires 21,2 %

Compléments du chapitre enrichi

Notion	À retenir
Transitions	Démographique (4 phases) ; épidémiologique (Omran, 1971) ; nutritionnelle (Popkin) ; double fardeau
Vieillissement	Indice = 65+ / moins de 20 ans × 100 ; dépendance = (moins de 20 + 65+) / 20-64 × 100
Fardeau	Adultes : 49 % surpoids dont 17 % obésité (Esteban 2015) ; 41 % des cancers liés à des facteurs modifiables (CIRC 2018) ; AVCI = AVP + AVI
Association	RR = R1/R0 ; DR = R1 − R0 ; OR = ad/bc ; FA = (RR − 1)/RR ; association ≠ causalité ; confusion
Inégalités	Obésité GS : 5,8 % (ouvriers) / 1,3 % (cadres) ; insécurité alimentaire 11 % (INCA 3) ; 16 % (Crédoc 2022) ; écart absolu et relatif
Enquêtes	INCA 3, Esteban, Albane, Elfe, NutriNet-Santé, Constances, SNDS ; transversale / cohorte / essai
Coût	Journée conforme aux repères ≈ 3,5 € (exemple) ; comparer par portion ; lentilles 0,16 € la portion
Périnatalité	Mortalité infantile ≈ 4 ‰ ; prématurité, petits poids, allaitement, certificats du 8e jour, 9e et 24e mois

Fiches-outils du chapitre 2

Outil	Intitulé	Utilité
O2.1	Grille des déterminants de l'alimentation de mon public	Analyser les causes d'un problème (F1, F2)
O2.2	Tableau d'indicateurs comparés territoire / référence	Construire le portrait chiffré
O2.3	Calcul d'un taux standardisé (méthode directe)	Comparer deux territoires
O2.4	Repérer les inégalités sociales et territoriales dans mon projet	Appliquer l'universalisme proportionné
O2.5	Grille de lecture critique d'un indicateur	Vérifier un chiffre avant de le citer

O2.1 – Grille des déterminants de l'alimentation de mon public

Catégorie	Déterminants observés (avec source)	Levier possible
Individuels (âge, santé, goûts, compétences, temps)		
Sociaux et culturels (famille, normes, religion, culture)		
Économiques (revenus, prix, aides)		
Environnement alimentaire (commerces, restauration, marketing)		
Environnement physique (logement, équipement, transports)		
Politiques et systèmes (cantine, aide alimentaire, programmes)		

O2.2 – Tableau d'indicateurs comparés

Indicateur	Mon territoire	Département	Région / France	Écart (points ou rapport)	Source et année
Population					
Moins de 20 ans (%)					
65 ans ou plus (%)					
Taux de pauvreté (%)					
Familles monoparentales (%)					
Sans diplôme (%)					
Espérance de vie / ICM					
Mortalité prématurée (taux standardisé)					
ALD diabète (taux standardisé)					
Surpoids des enfants					

O2.3 – Calcul d'un taux standardisé (méthode directe)

Âge	Pop. A	Décès A	Taux A (‰)	Pop. B	Décès B	Taux B (‰)	Pop. de référence
Total							

Calcul	Territoire A	Territoire B
Taux brut = décès / population × 1 000		
Décès attendus = (taux spécifique × pop. de référence / 1 Σ 000)		
Taux standardisé = décès attendus / pop. de référence × 1 000		
Conclusion		

O2.4 – Repérer les inégalités dans mon projet

Question	Réponse
Quels groupes de mon public sont les plus défavorisés	
(revenu, quartier, langue, handicap, isolement) ?	
Quelles barrières risquent de les empêcher de participer	
(horaires, coût, transport, lecture, numérique) ?	
Quelle partie de l'action est universelle (pour tous) ?	
Quel renforcement pour les plus défavorisés	
(universalisme proportionné) ?	
Quel indicateur me permettra de vérifier que l'action	
profite aussi aux plus défavorisés ?	
Quelles précautions pour ne pas stigmatiser ?	

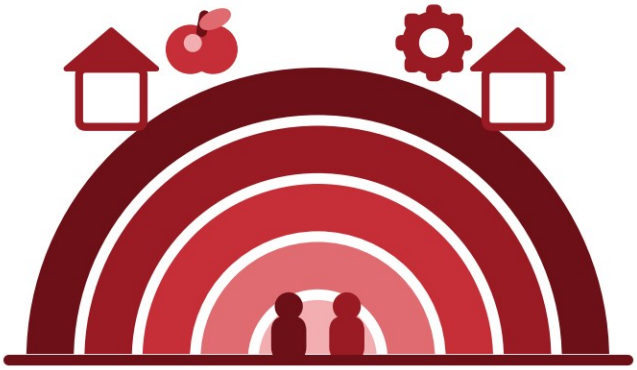
O2.5 – Grille de lecture critique d'un indicateur

Question	Réponse	OK ?
Quel est l'indicateur exact (numérateur, dénominateur, unité) ?		☐
Quelle population (âge, sexe, territoire) ?		☐
Quelle année de recueil ?		☐
Mesuré ou déclaré ? Quel échantillon ?		☐
Taux brut ou standardisé ?		☐
Quelle valeur de référence pour comparer ?		☐
Quelle source (organisme, document, lien) ?		☐

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES



CHAPITRE

02

Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé

Déterminants de santé | Inégalités | Mesure de l'état de santé

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 2 110
Mode d'emploi du cahier 110
Partie 1 – Les déterminants de santé 111
Exercice 2.1 – Légender le modèle de Lalonde (8 points) 112
Exercice 2.2 – Classer des déterminants dans le modèle de Dahlgren et Whitehead (10 points) 114
Exercice 2.3 – Déterminants structurels et intermédiaires (12 points) 116
Exercice 2.4 – Analyser les déterminants de l'alimentation d'un public (12 points) 118
Exercice 2.5 – Caractériser l'environnement alimentaire de deux quartiers (12 points) 120
Exercice 2.6 – Un village sans commerce (16 points) 122
Corrigés de la partie 1 124
Partie 2 – Les inégalités sociales et territoriales de santé 127
Exercice 2.7 – Inégalité ou simple différence ? (8 points) 128
Exercice 2.8 – Légender et expliquer le gradient social (10 points) 129
Exercice 2.9 – Mesurer une inégalité selon le diplôme (12 points) 131
Exercice 2.10 – Une action a-t-elle réduit les inégalités ? (12 points) 132
Exercice 2.11 – Comparer trois territoires avec des indices comparatifs (12 points) 133
Exercice 2.12 – Construire une action en universalisme proportionné (16 points) 134
Corrigés de la partie 2 136
Partie 3 – Les indicateurs démographiques 138
Exercice 2.13 – Effectif, proportion, taux ou indice ? (6 points) 139
Exercice 2.14 – Lire deux pyramides des âges (10 points) 140
Exercice 2.15 – Natalité, mortalité et soldes d'une commune (12 points) 142
Exercice 2.16 – Comparer le vieillissement de deux territoires (12 points) 143
Exercice 2.17 – Espérance de vie et espérance de vie sans incapacité (10 points) 144
Exercice 2.18 – Choisir un public prioritaire à partir de la démographie (16 points) 145
Corrigés de la partie 3 147
Partie 4 – Mortalité, morbidité et standardisation 149
Exercice 2.19 – Calculer des taux de mortalité (10 points) 150
Exercice 2.20 – Légender les deux méthodes de standardisation (8 points) 152
Exercice 2.21 – Standardisation directe : deux communes (14 points) 153
Exercice 2.22 – Méthode indirecte : un petit quartier (12 points) 154
Exercice 2.23 – Prévalence et incidence du diabète (12 points) 155
Exercice 2.24 – Comparer deux territoires pour choisir où agir (16 points) 156
Corrigés de la partie 4 158
Partie 5 – Sources de données, portrait de territoire et état nutritionnel 160
Exercice 2.25 – Légender la carte des sources de données (10 points) 161
Exercice 2.26 – Trouver la bonne source (10 points) 163
Exercice 2.27 – IMC et prévalences mesurées (12 points) 164
Exercice 2.28 – Mesuré ou déclaré, adulte ou enfant (10 points) 166
Exercice 2.29 – La précision d'une prévalence (12 points) 167
Exercice 2.30 – Construire le portrait de santé d'un quartier (18 points) 168
Corrigés de la partie 5 170
Partie 6 – Transitions et fardeau des maladies chroniques 172
Exercice 2.31 – Légender la transition démographique (10 points) 173
Exercice 2.32 – Reconnaître les stades de la transition nutritionnelle (8 points) 175
Exercice 2.33 – Le double fardeau de la malnutrition (12 points) 176
Exercice 2.34 – Calculer des AVCI (12 points) 177
Exercice 2.35 – Cancers attribuables à des facteurs nutritionnels (12 points) 178

Exercice 2.36 – Convaincre des élus de la priorité nutritionnelle (16 points) 179
Corrigés de la partie 6 181

Partie 7 – Mesurer une association, raisonner sur la causalité 183
Exercice 2.37 – Légender le tableau de contingence (8 points) 184
Exercice 2.38 – Petit-déjeuner et surpoids au collège (14 points) 185
Exercice 2.39 – Sel et hypertension : fractions attribuables (10 points) 186
Exercice 2.40 – Démasquer un facteur de confusion (14 points) 187
Exercice 2.41 – Types d'études et niveau de preuve (10 points) 189
Exercice 2.42 – Lecture critique d'un article de presse (14 points) 190
Corrigés de la partie 7 191

Partie 8 – Représenter des données, coût de l'alimentation, agir sur les déterminants 193
Exercice 2.43 – Choisir le bon graphique (10 points) 194
Exercice 2.44 – Commenter des données en cinq phrases (10 points) 196
Exercice 2.45 – Le coût des protéines (12 points) 197
Exercice 2.46 – Leviers d'action et évaluation d'impact sur la santé (14 points) 198
Exercice 2.47 – Indicateurs de périnatalité (10 points) 199
Exercice 2.48 – Cas complet : le collège des Peupliers (40 points) 200
Corrigés de la partie 8 203

Bilan : grille d'auto-évaluation 206

Cahier d'exercices – Chapitre 2

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 2 : déterminants de santé, inégalités sociales et territoriales de santé, indicateurs démographiques, de mortalité, de morbidité et d'état nutritionnel, sources de données, transitions, fardeau des maladies chroniques, mesures d'association (référentiel du 27 novembre 2024, compétence C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition » et savoirs associés « Enjeux de santé publique » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : modèles de Lalonde, de Dahlgren et Whitehead et de la Commission des déterminants sociaux de la santé, gradient social, pyramides des âges, standardisation, transition démographique, tableau de contingence, facteur de confusion, sources de données, choix d'un graphique.
- Calculer et interpréter des taux, des proportions, des taux standardisés, un rapport standardisé de mortalité, des prévalences, des incidences, des AVCI, un risque relatif, un odds ratio et des fractions attribuables.
- Construire un portrait de santé de territoire et en tirer des constats sourcés, datés et utiles pour choisir un public prioritaire.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits de textes), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes et chiffres locaux des mises en situation sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les données nationales, les textes et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026 ; chaque donnée réelle est suivie de sa source et de son année. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, publiée le 19 novembre 2025). Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés.

Méthode – Rédiger un calcul au BTS

Pour chaque calcul, écrivez quatre lignes : la formule en toutes lettres, l'application numérique, le résultat arrondi avec son unité (%, ‰, pour 100 000, €), puis une phrase d'interprétation qui dit ce que le chiffre change pour l'action. Le jury note la démarche autant que le résultat.

Partie 1 – Les déterminants de santé

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir un déterminant de santé et distinguer déterminant modifiable et non modifiable, facteur de risque et facteur de protection.
- Présenter et légender les modèles de Lalonde (1974), de Dahlgren et Whitehead (1991) et de la Commission des déterminants sociaux de la santé (OMS, 2008).
- Analyser les déterminants des comportements alimentaires d'un public et en déduire des leviers d'action.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Déterminant de santé : facteur personnel, social, économique, environnemental ou politique qui influence l'état de santé d'une personne ou d'une population (OMS, glossaire de la promotion de la santé, 1998).
- Lalonde (Canada, 1974) : quatre champs, biologie humaine, environnement, habitudes de vie, organisation des soins.
- Dahlgren et Whitehead (1991) : cinq couches, de l'individu (âge, sexe, hérédité) aux conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales.
- Commission des déterminants sociaux de la santé (OMS, 2008 ; cadre de Solar et Irwin, 2010) : déterminants structurels (contexte et position sociale) et déterminants intermédiaires (conditions matérielles, facteurs psychosociaux, comportements, système de santé).
- Environnement alimentaire : disponibilité, accessibilité physique et financière, attractivité et qualité des aliments. Désert alimentaire : accès difficile aux produits frais. Marais alimentaire : offre saturée de restauration rapide.

Exercice 2.1 – Légender le modèle de Lalonde (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une intervention de 15 minutes devant des élèves infirmiers en stage dans une maison de santé pluriprofessionnelle. Vous voulez leur montrer que l'organisation des soins n'est qu'un des déterminants de l'état de santé.

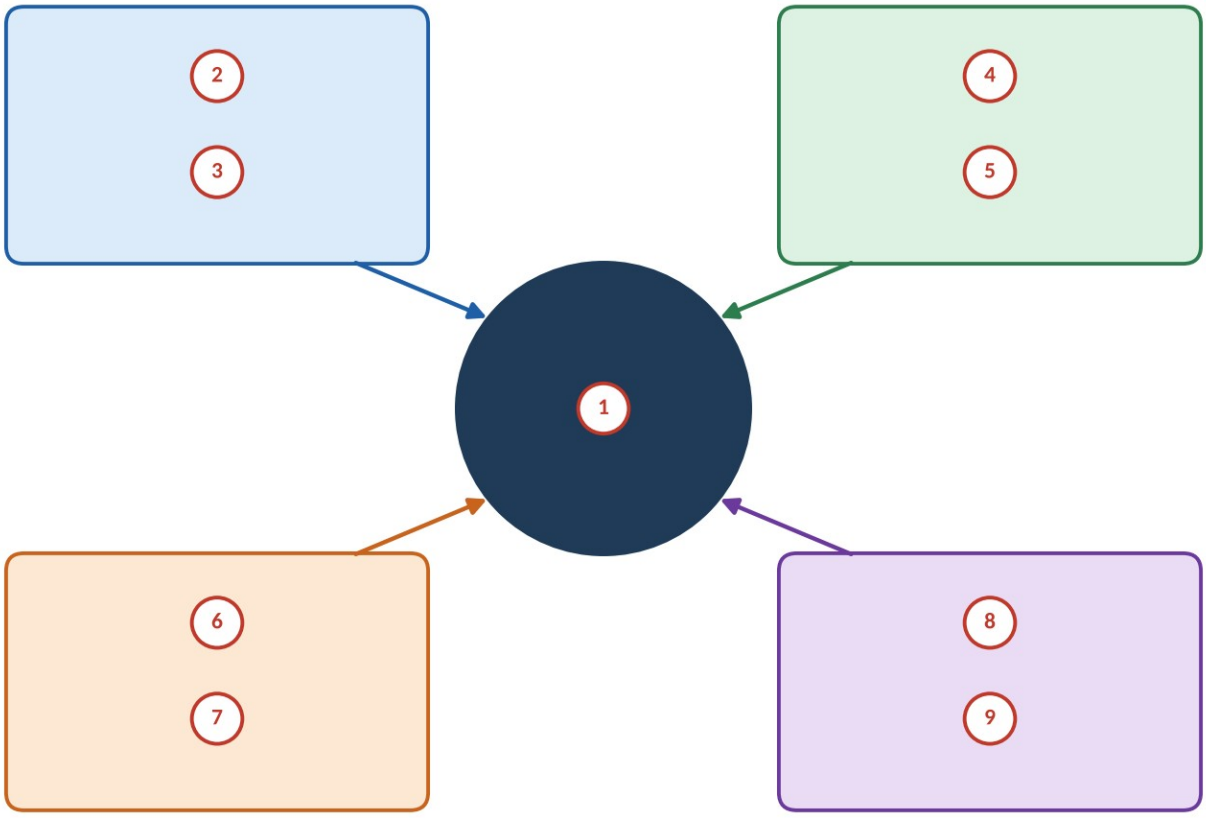


Figure 2.1 – Document 1 – Le « champ de la santé » de Marc Lalonde (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)
2. Indiquez le pays, l'année et le message principal du rapport Lalonde. (1,5 pt)
3. Présentez une limite de ce modèle, en vous appuyant sur l'exemple d'une personne au chômage qui a une alimentation peu variée. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.2 – Classer des déterminants dans le modèle de Dahlgren et Whitehead (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans un service de santé au travail interentreprises. Le médecin du travail vous présente le cas de M. K., 47 ans, chauffeur routier international, pour qui un diabète de type 2 vient d'être découvert. Il vous demande d'analyser la situation avec le modèle de Dahlgren et Whitehead avant de proposer un accompagnement.

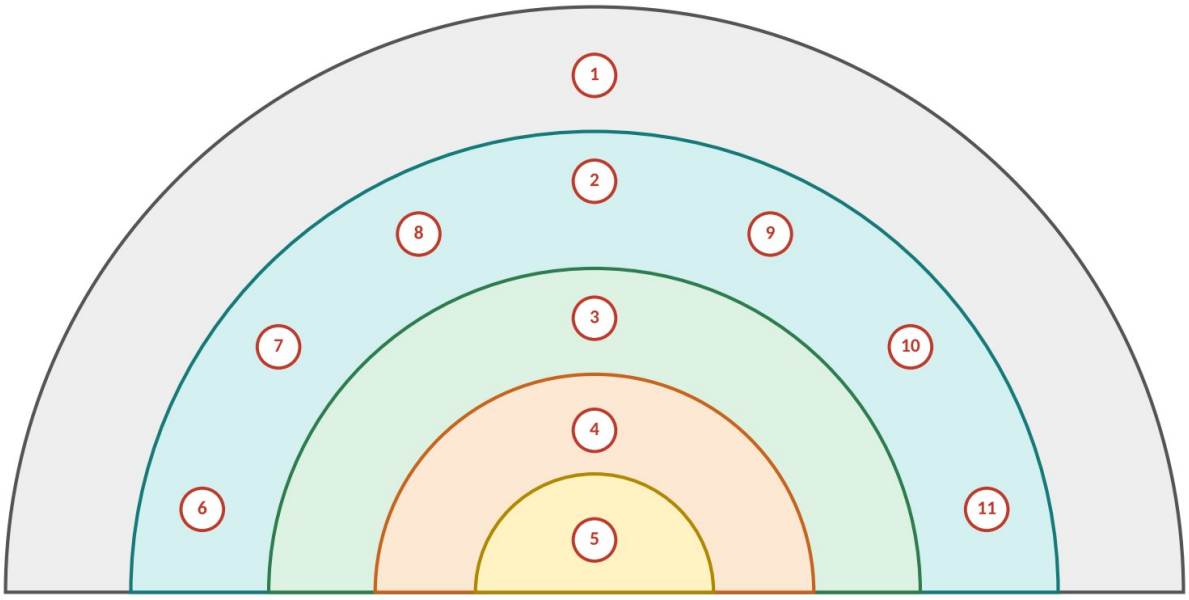


Figure 2.2 – Document 1 – Le modèle de Dahlgren et Whitehead (schéma à légender)

Document 2 – Ce que dit M. K.

« Mon père était diabétique. Je roule de nuit trois fois par semaine, je mange sur les aires d'autoroute, là où je peux me garer. Je dors dans la cabine, je n'ai qu'une glacière. Ma femme et mes enfants, je les vois le week-end. Les délais de livraison sont serrés : si je m'arrête une heure pour manger, je suis en retard. Le médecin, je n'y vais jamais, il n'y en a plus dans mon village. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 11 du document 1. (4 pts)
2. Classez chaque élément du document 2 dans une couche du modèle. (4 pts)
3. Indiquez la couche sur laquelle un diététicien peut agir seul et celle qui exige d'autres acteurs ; justifiez. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.3 – Déterminants structurels et intermédiaires (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de quartier veut lancer des ateliers « bien manger » et vous demande pourquoi les habitants les plus pauvres risquent de moins en profiter que les autres. Vous vous appuyez sur le cadre de la Commission des déterminants sociaux de la santé.

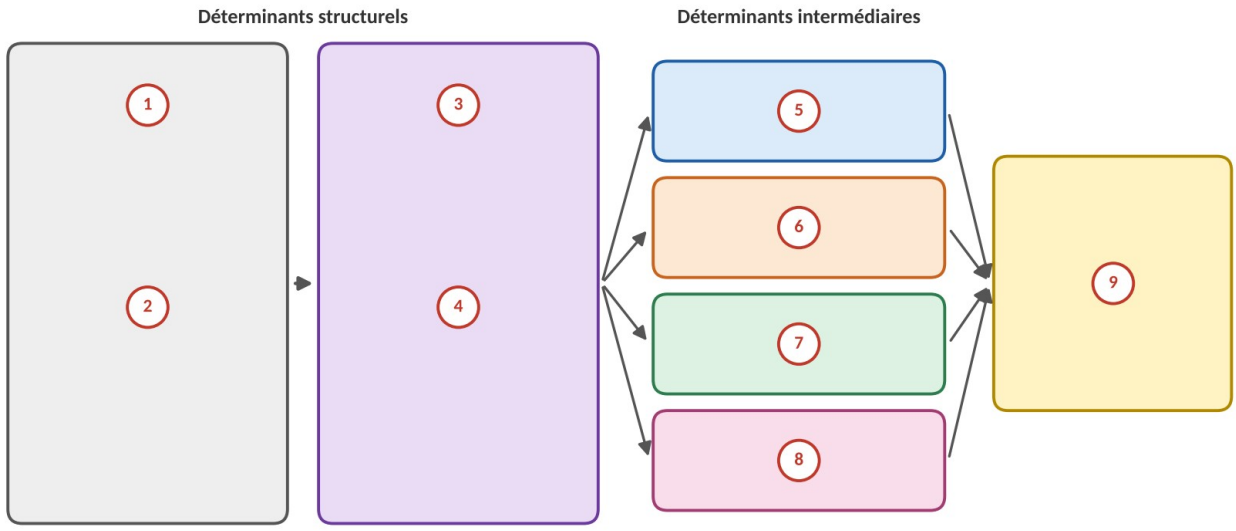


Figure 2.3 – Document 1 – Cadre conceptuel des déterminants sociaux de la santé (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)
2. Distinguez déterminants structurels et déterminants intermédiaires ; donnez deux exemples de chaque en lien avec l'alimentation. (3 pts)
3. Expliquez, à l'aide des flèches du schéma, pourquoi des ateliers qui n'agissent que sur les comportements ne réduisent pas les inégalités. (2,5 pts)
4. Proposez deux actions complémentaires qui agissent sur les conditions matérielles. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.4 – Analyser les déterminants de l'alimentation d'un public (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une entreprise de transport de 140 salariés, dont 96 chauffeurs, a signé une convention avec le service de santé au travail. Elle veut une action sur l'alimentation de ses chauffeurs. Vous avez mené six entretiens et observé deux aires de repos.

Document 1 – Extraits des entretiens et des observations

- « Le soir, on mange ce qu'il y a au distributeur ou au relais routier ; un plat du jour coûte 16 €, la prime de repas est de 15,80 €. »
- « Entre collègues, on se moque de celui qui sort sa salade. »
- « Je ne sais pas trop ce qu'il faut manger quand on est assis 10 heures par jour. »
- Sur les deux aires observées : 1 distributeur de sandwichs, 1 boutique de station-service (viennoiseries, barres chocolatées, boissons sucrées) ; aucun fruit frais en vente.
- Les camions récents ont une prise 24 V ; l'entreprise ne fournit ni glacière électrique ni réfrigérateur de cabine.
- La réglementation impose une pause de 45 minutes après 4 h 30 de conduite.

À vous de jouer – Questions

1. Classez les éléments du document 1 selon les six familles de déterminants de l'alimentation : individuels, sociaux et culturels, économiques, environnement alimentaire, environnement physique, politiques et règles. (6 pts)

2. Indiquez, pour trois de ces familles, un levier d'action précis et réaliste. (4,5 pts)

3. Expliquez pourquoi une simple brochure « bien manger sur la route » aurait peu d'effet. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.5 – Caractériser l'environnement alimentaire de deux quartiers (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre du diagnostic du projet alimentaire territorial d'une agglomération (données fictives), vous comparez l'offre alimentaire de deux quartiers. Vous avez recensé les commerces à pied, sur place.

Document 1 – Recensement des commerces alimentaires (relevé de terrain, mars 2026)

Commerces	Quartier de Bellevue (6 300 habitants)	Centre-ville (9 800 habitants)
Supermarché	0	2
Supérette	1	0
Primeur	0	3
Marché de plein vent (jour de marché)	1 (le samedi)	2
Commerces proposant des fruits et légumes frais (total)	2	7
Restauration rapide et vente à emporter	11	9

À vous de jouer – Questions

1. Définissez l'environnement alimentaire, le désert alimentaire et le marais alimentaire. (3 pts)
2. Calculez, pour chaque quartier, le nombre de commerces de fruits et légumes frais et le nombre de points de restauration rapide pour 10 000 habitants. (3 pts)
3. Calculez, pour chaque quartier, le rapport « restauration rapide / commerces de produits frais » ; interprétez. (3 pts)
4. Présentez deux limites de ce recensement et une action possible pour Bellevue. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.6 – Un village sans commerce (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au centre intercommunal d'action sociale (CIAS) d'une communauté de communes rurale. La dernière épicerie de Saint-Rémy (780 habitants, données fictives) a fermé il y a un an. Le supermarché le plus proche est à 14 km. Le maire a reçu des plaintes de personnes âgées et souhaite une analyse de la situation avant de décider.

Document 1 – Données du CIAS sur Saint-Rémy (2026, fictives)

- 212 habitants ont 65 ans ou plus ; 46 d'entre eux n'ont pas de voiture ou ne conduisent plus.
- Un car passe 2 fois par jour vers le bourg-centre, mais pas le samedi.
- Le portage de repas existe à 7,90 € le repas ; 9 personnes l'utilisent.
- Un producteur de légumes vend à la ferme le vendredi, à 3 km du village.
- La salle des fêtes est équipée d'une cuisine et est libre en semaine.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part des 65 ans ou plus dans la population et la part, parmi eux, des personnes sans voiture. (2 pts)
2. Calculez la distance parcourue en un an par une personne qui fait ses courses une fois par semaine au supermarché (aller et retour). (1 pt)
3. Analysez la situation avec le modèle de Dahlgren et Whitehead : un élément par couche. (5 pts)
4. Identifiez deux risques nutritionnels pour les personnes âgées sans voiture. (2 pts)
5. Proposez trois actions, chacune sur une couche différente du modèle, et indiquez les partenaires. (6 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 2.1

1. Légendes : 1 État de santé ; 2 Biologie humaine ; 3 génétique, âge, sexe, fonctionnement du corps ; 4 Environnement ; 5 physique et social : logement, travail, revenus ; 6 Habitudes de vie ; 7 alimentation, activité physique, tabac, alcool ; 8 Organisation des soins ; 9 accès, qualité et quantité des soins.
2. Canada, 1974, rapport du ministre de la Santé Marc Lalonde, « Nouvelle perspective de la santé des Canadiens ». Message : presque toutes les dépenses de santé allaient aux soins, alors que la biologie, l'environnement et les habitudes de vie pèsent davantage sur la mortalité ; il faut donc investir dans la prévention.
3. Le modèle place les « habitudes de vie » au même niveau que les autres champs, sans montrer qu'elles dépendent des conditions de vie. On risque de rendre la personne au chômage seule responsable de son alimentation, alors que son revenu, son moral et l'offre de son quartier limitent ses choix. Le modèle a parfois servi à culpabiliser l'individu.

Corrigé – Exercice 2.2

1. Légendes : 1 Conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales ; 2 Conditions de vie et de travail ; 3 Réseaux sociaux et communautaires ; 4 Facteurs liés au mode de vie personnel ; 5 Âge, sexe et facteurs héréditaires ; 6 Agriculture et production alimentaire ; 7 Éducation ; 8 Environnement de travail ; 9 Eau et assainissement ; 10 Services de santé ; 11 Logement.
2. Âge, sexe, hérédité : 47 ans, homme, père diabétique. Mode de vie : repas pris sur les aires, sédentarité au volant, sommeil de nuit perturbé. Réseaux sociaux : famille vue seulement le week-end, isolement pendant la semaine. Conditions de vie et de travail : travail de nuit, délais serrés, cabine avec une glacière seulement, offre des aires d'autoroute, absence de médecin au village (services de santé). Conditions générales : organisation du transport routier et des délais de livraison, désertification médicale rurale.
3. Le diététicien peut agir seul sur le mode de vie (conseils adaptés, repas à préparer à l'avance, choix sur les aires). Les conditions de travail (équipement de la cabine, temps de pause réel, offre des aires) exigent l'employeur, le service de santé au travail et les gestionnaires d'autoroute. Ce sont pourtant elles qui rendent les conseils applicables.

Corrigé – Exercice 2.3

1. Légendes : 1 Contexte socio-économique et politique ; 2 gouvernance, politiques sociales et de santé, normes culturelles ; 3 Position socio-économique ; 4 revenu, éducation, profession, genre, origine ; 5 Conditions matérielles ; 6 Facteurs psychosociaux ; 7 Comportements et facteurs biologiques ; 8 Système de santé ; 9 Équité en santé et bien-être.
2. Les déterminants structurels créent la position sociale des personnes : contexte (montant des minima sociaux, prix des aliments, politique du logement) et position sociale (revenu, diplôme, emploi). Les déterminants intermédiaires sont les canaux par lesquels la position sociale agit : conditions matérielles (cuisine équipée, commerces accessibles), facteurs psychosociaux (stress, isolement), comportements (consommation de fruits et légumes), système de santé.
3. Les flèches partent du contexte et de la position sociale vers les déterminants intermédiaires, puis vers la santé. Un atelier agit sur un comportement, mais la cause en amont (faible revenu, logement sans cuisine) demeure. Les personnes les plus aisées, qui ont plus de ressources, appliquent plus facilement les conseils ; l'écart peut même se creuser.
4. Exemples : partenariat avec une épicerie solidaire ou des paniers de fruits et légumes à prix réduit ; prêt de matériel de cuisine ou cuisine collective accessible au centre social ; aide pour ouvrir les droits (chèques alimentaires, tarification sociale de la cantine).

Corrigé – Exercice 2.4

1. Individuels : manque de connaissances sur les besoins d'une personne sédentaire. Sociaux et culturels : moqueries des collègues, norme du groupe défavorable aux plats légers. Économiques : plat du jour à 16 € pour une prime de 15,80 €. Environnement alimentaire : distributeur et boutique de station-service, aucun fruit frais. Environnement physique : pas de glacière électrique ni de réfrigérateur alors qu'une prise 24 V existe. Politiques et règles : pause obligatoire de 45 minutes après 4 h 30 de conduite (c'est une ressource : un temps de repas existe).
2. Exemples : environnement physique, l'entreprise équipe les cabines de glacières électriques 24 V ; environnement alimentaire, un partenariat avec un relais routier pour un plat équilibré au prix de la prime ; social, un atelier collectif où les chauffeurs préparent et goûtent des repas transportables, pour faire évoluer la norme du groupe ; individuel, un repère simple de composition de la gamelle.
3. La brochure agit seulement sur les connaissances, alors que les freins principaux sont matériels (pas de froid), économiques (prix) et sociaux (moqueries). Sans changement de l'environnement, l'information ne se traduit pas en comportement.

Corrigé – Exercice 2.5

1. Environnement alimentaire : ensemble des conditions physiques, économiques, politiques et socioculturelles qui déterminent la disponibilité, l'accessibilité, l'attractivité et la qualité des aliments dans la vie quotidienne. Désert alimentaire : zone où l'accès physique à des aliments frais est difficile. Marais alimentaire : zone saturée d'offre de restauration rapide et d'aliments peu favorables à la santé.
2. Formule : nombre de commerces / nombre d'habitants × 10 000. Bellevue : produits frais 2 / 6 300 × 10 000 = 3,17 ; restauration rapide 11 / 6 300 × 10 000 = 17,46. Centre-ville : produits frais 7 / 9 800 × 10 000 = 7,14 ; restauration rapide 9 / 9 800 × 10 000 = 9,18.
3. Bellevue : 11 / 2 = 5,50 ; centre-ville : 9 / 7 = 1,29. À Bellevue, il y a 5,5 points de restauration rapide pour un commerce de produits frais, contre 1,3 au centre. Bellevue cumule les caractères d'un désert alimentaire (peu de produits frais, marché une seule fois par semaine) et d'un marais alimentaire.
4. Limites : le nombre de commerces ne dit rien de leur taille, de leurs prix ni de leurs horaires ; les habitants peuvent faire leurs courses ailleurs (lieu de travail, voiture) ; un relevé ponctuel ne voit pas la vente en ligne. Action : un marché ou une vente de paniers de fruits et légumes en semaine au pied des immeubles, en lien avec le centre social et des producteurs du projet alimentaire territorial.

Corrigé – Exercice 2.6

1. Part des 65 ans ou plus : 212 / 780 × 100 = 27,2 %. Part des personnes sans voiture parmi eux : 46 / 212 × 100 = 21,7 %.
2. Distance annuelle : 2 × 14 km × 52 semaines = 1 456 km par an.
3. Âge, sexe, hérédité : population âgée (27,2 % de 65 ans ou plus). Mode de vie : courses moins fréquentes, repas plus monotones, moins de produits frais. Réseaux sociaux : dépendance aux voisins ou à la famille pour les courses, risque d'isolement. Conditions de vie : fermeture de l'épicerie, pas de car le samedi, portage de repas payant. Conditions générales : désertification commerciale des zones rurales, politiques de transport et du vieillissement.
4. Risques : dénutrition (apports insuffisants en énergie et en protéines, repas sautés) ; apports faibles en fruits et légumes frais, donc en fibres et en vitamine C ; perte de poids et perte d'autonomie qui aggravent l'isolement.
5. Exemples : réseaux sociaux, des repas partagés hebdomadaires dans la salle des fêtes avec l'association des aînés et le CIAS ; conditions de vie, un transport à la demande vers le marché ou le supermarché, financé par la communauté de communes, et un point de retrait de paniers du producteur à la mairie le vendredi ; mode de vie, des ateliers « cuisine simple pour une personne » animés par un diététicien, financés par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Conditions

générales : plaidoyer auprès des élus pour une épicerie itinérante ou un commerce multiservices.

Partie 2 – Les inégalités sociales et territoriales de santé

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir les inégalités sociales de santé et le gradient social ; distinguer une inégalité d'une simple différence.
- Expliquer les mécanismes qui produisent les inégalités (matériels, psychosociaux, comportementaux, accès aux soins, parcours de vie).
- Mesurer une inégalité par l'écart absolu et l'écart relatif ; évaluer si une action réduit ou creuse les inégalités.
- Comparer des territoires avec des indices comparatifs et appliquer l'universalisme proportionné.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Inégalités sociales de santé : différences d'état de santé systématiques, socialement produites, donc évitables, et injustes entre groupes sociaux.
- Gradient social : la santé s'améliore à chaque échelon de l'échelle sociale, pas seulement entre les plus pauvres et les autres.
- Espérance de vie à la naissance : environ 13 ans d'écart chez les hommes (71,7 ans contre 84,4 ans) et 8 ans chez les femmes (80,0 ans contre 88,3 ans) entre les 5 % les plus modestes et les 5 % les plus aisés (Insee, 2018, données 2012-2016).
- Écart absolu = p(défavorisés) − p(favorisés), en points. Écart relatif = p(défavorisés) / p(favorisés), sans unité.
- Universalisme proportionné (Marmot, 2010) : une action pour tous, avec une intensité proportionnée au niveau de désavantage.
- Indice comparatif = valeur du territoire / valeur de référence × 100 (100 = même niveau que la référence).

Exercice 2.7 – Inégalité ou simple différence ? (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un diaporama de présentation de votre stage, vous voulez illustrer la notion d'inégalité sociale de santé. Votre tutrice vous propose cinq constats et vous demande lesquels sont de vraies inégalités sociales de santé.

Document 1 – Cinq constats

a) Les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes.

b) Les enfants d'ouvriers de grande section sont plus souvent en surpoids que les enfants de cadres (16 % contre 7 %, Drees, données 2012-2013).

c) Les personnes de 80 ans sont plus souvent dénutries que les personnes de 40 ans.

d) Les adultes non diplômés ont moins souvent recours au dépistage du cancer colorectal que les diplômés du supérieur.

e) La mortalité standardisée est plus élevée à Mayotte que dans l'Hexagone (89 % au-dessus de la moyenne nationale en 2023, Inserm-CépiDc, 2025).

À vous de jouer – Questions

1. Donnez la définition des inégalités sociales de santé et ses trois caractéristiques. (2 pts)

2. Classez chaque constat : inégalité sociale, inégalité territoriale ou différence non sociale ; justifiez. (5 pts)

3. Expliquez pourquoi la différence du constat a) peut contenir une part d'inégalité sociale. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.8 – Légender et expliquer le gradient social (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un comité de pilotage, un élu affirme : « Les problèmes de santé, ça concerne les 10 % les plus pauvres ; pour les autres, tout va bien. » Vous préparez une réponse avec un schéma.

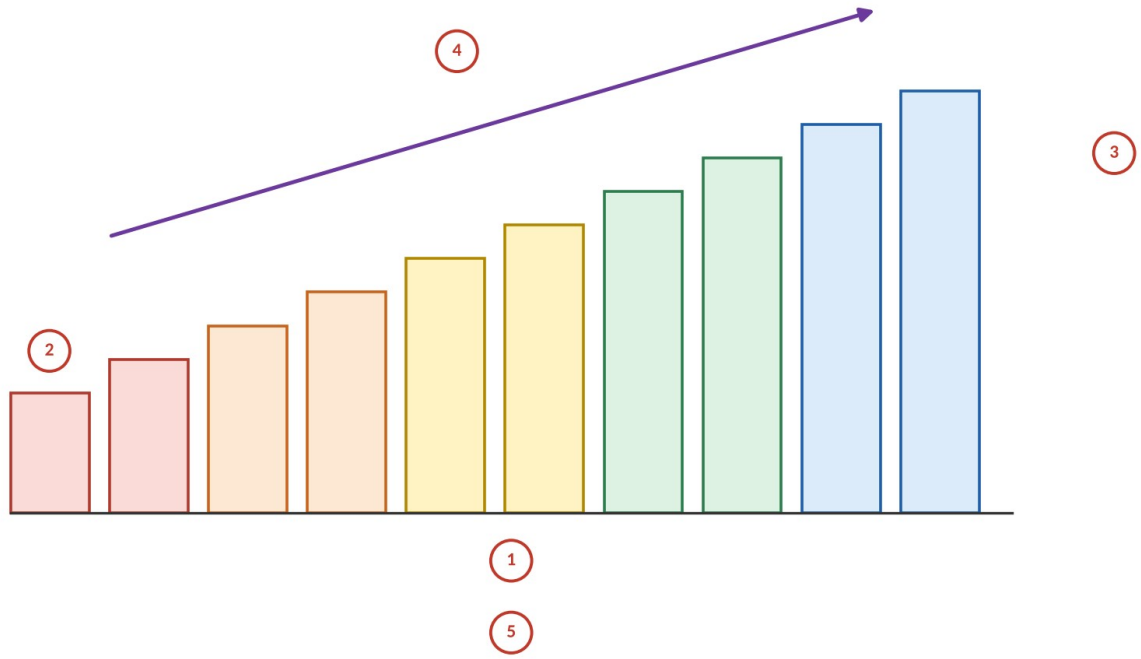


Figure 2.4 – Document 1 – Le gradient social de santé (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Définissez le gradient social de santé. (2 pts)
3. Citez les données de l'Insee sur l'espérance de vie selon le niveau de vie, avec l'année. (2 pts)
4. Répondez à l'élu en trois phrases, en tirant une conséquence pour l'action. (3,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.9 – Mesurer une inégalité selon le diplôme (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'observatoire régional de la santé a mené une enquête avec mesure du poids et de la taille auprès de 4 000 adultes (données fictives, 2025). Vous devez commenter les résultats pour le rapport annuel.

Document 1 – Adultes en situation d'obésité (IMC ≥ 30) selon le diplôme (enquête fictive, 2025)

Diplôme le plus élevé	Effectif mesuré	Adultes obèses
Aucun diplôme	820	197
CAP ou BEP	1 140	222
Baccalauréat	960	136
Diplôme du supérieur	1 080	109
Ensemble	4 000	664

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la prévalence de l'obésité dans chaque groupe et dans l'ensemble. (4 pts)
2. Calculez l'écart absolu et l'écart relatif entre les non-diplômés et les diplômés du supérieur. (2 pts)
3. Rédigez un commentaire de quatre phrases (présentation, tendance, valeurs extrêmes, interprétation). (4 pts)
4. Expliquez pourquoi le diplôme est un bon indicateur de position sociale dans ce type d'enquête. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.10 – Une action a-t-elle réduit les inégalités ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une ville a mené deux actions pendant un an (données fictives). L'action 1 a distribué des fruits au goûter dans les écoles, deux fois plus souvent dans les écoles du quartier prioritaire. L'action 2 est une campagne d'affichage identique dans toute la ville sur la consommation de légumes secs.

Document 1 – Résultats avant et après (données fictives)

Indicateur	Groupe	Avant	Après
Action 1 : enfants mangeant un fruit au goûter au moins 3 jours par semaine	Quartier prioritaire	22 %	34 %
	Autres quartiers	41 %	47 %
Action 2 : adultes consommant des légumes secs au moins 2 fois par semaine	Ouvriers et employés	30 %	32 %
	Cadres et professions intermédiaires	45 %	53 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque action, l'écart absolu et l'écart relatif avant et après. (4 pts)
2. Indiquez, pour chaque action, si l'inégalité s'est réduite ou creusée ; justifiez par la progression de chaque groupe. (3 pts)
3. Nommez le principe appliqué dans l'action 1 et le phénomène observé dans l'action 2. (2 pts)
4. Proposez une modification de l'action 2 pour qu'elle bénéficie davantage aux ouvriers et employés. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.11 – Comparer trois territoires avec des indices comparatifs (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une agence régionale de santé fictive doit choisir le territoire où lancer en priorité un programme de prévention du diabète de type 2. Vous disposez de trois indicateurs pour trois territoires et pour la région.

Document 1 – Indicateurs de trois territoires (données fictives, moyennes 2021-2023)

Indicateur	Territoire A	Territoire B	Territoire C	Région (référence)
Mortalité prématurée standardisée (décès avant 65 ans pour 100 000)	245	172	214	190
Part de la population traitée pour un diabète (%)	7,1	4,8	6,0	5,4
Taux de pauvreté (%)	21,4	11,2	16,9	14,5

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'indice comparatif (base 100 = région) de chaque territoire pour chaque indicateur. (4,5 pts)

2. Classez les territoires et choisissez celui à retenir en priorité ; justifiez. (3 pts)

3. Expliquez pourquoi on utilise une mortalité standardisée et non un taux brut. (2 pts)

4. Indiquez deux précautions avant de conclure (données, causes). (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.12 – Construire une action en universalisme proportionné (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au service de santé d'une ville de 42 000 habitants (données fictives). La ville veut proposer à toutes les familles des ateliers « cuisine du quotidien » pour les parents d'enfants de 3 à 11 ans. Elle dispose de 9 000 € pour un an. Trois secteurs existent : le centre (taux de pauvreté 9 %), les quartiers pavillonnaires (12 %) et le quartier prioritaire des Glycines (38 %).

Document 1 – Contraintes relevées

- Les familles du quartier des Glycines disent ne pas venir aux ateliers du centre-ville : « C'est loin, il faut prendre deux bus, et on ne connaît personne. »
- 31 % des familles des Glycines n'ont pas de connexion internet à domicile.
- Le centre social des Glycines dispose d'une cuisine pédagogique ; les associations de parents y sont actives.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi une offre identique dans les trois secteurs risquerait de creuser les inégalités. (3 pts)
2. Définissez l'universalisme proportionné et citez son auteur et l'année. (2 pts)
3. Proposez une organisation des ateliers pour les trois secteurs, avec une intensité graduée (nombre d'ateliers, lieu, mode d'inscription, coût). (6 pts)
4. Proposez une répartition du budget entre les secteurs et justifiez-la. (2 pts)
5. Proposez deux indicateurs d'évaluation qui permettront de vérifier que l'action réduit les inégalités. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 2.7

1. Les inégalités sociales de santé sont des différences d'état de santé entre groupes sociaux qui sont systématiques (elles se retrouvent dans toutes les études), socialement produites, donc évitables, et injustes.

2. a) Différence en grande partie non sociale : il existe une part biologique, mais aussi des comportements liés au genre (voir question 3). b) Inégalité sociale : l'écart selon la profession des parents est systématique et évitable. c) Différence non sociale : elle est liée à l'âge, déterminant non modifiable. d) Inégalité sociale : le recours à la prévention dépend du diplôme, donc de la littératie et de l'accès. e) Inégalité territoriale : la mortalité dépend du lieu de vie, qui concentre pauvreté, offre de soins plus faible et conditions de vie difficiles.

3. Une partie de l'écart entre hommes et femmes vient de comportements construits socialement (tabac, alcool, prise de risque, métiers pénibles plus souvent masculins). Cette part-là est évitable.

Corrigé – Exercice 2.8

1. Légendes : 1 Position sociale (du niveau de vie le plus modeste au plus aisé) ; 2 Les plus modestes : santé la moins bonne ; 3 Les plus aisés : santé la meilleure ; 4 Gradient social : la santé s'améliore à chaque échelon ; 5 Hommes : environ 13 ans d'écart d'espérance de vie entre les 5 % les plus modestes et les 5 % les plus aisés (Insee, 2018).

2. Le gradient social de santé décrit l'amélioration progressive de l'état de santé à chaque échelon de l'échelle sociale : chaque groupe a une santé moins bonne que le groupe situé juste au-dessus.

3. Insee (2018, données 2012-2016) : chez les hommes, 71,7 ans pour les 5 % les plus modestes contre 84,4 ans pour les 5 % les plus aisés, soit environ 13 ans d'écart ; chez les femmes, 80,0 ans contre 88,3 ans, soit environ 8 ans. Autour de 1 000 euros par mois, 100 euros de niveau de vie en plus sont associés à 0,9 an d'espérance de vie en plus chez les hommes.

4. « Les données de l'Insee montrent que l'espérance de vie augmente à chaque niveau de revenu, et pas seulement entre les plus pauvres et les autres. Les classes moyennes ont elles aussi une santé moins bonne que les plus aisés. Notre action doit donc s'adresser à toutes les familles, avec plus de moyens pour celles qui en ont le plus besoin : c'est l'universalisme proportionné. »

Corrigé – Exercice 2.9

1. Prévalence = adultes obèses / effectif mesuré × 100. Aucun diplôme : 197 / 820 × 100 = 24,0 % ; CAP ou BEP : 222 / 1 140 × 100 = 19,5 % ; baccalauréat : 136 / 960 × 100 = 14,2 % ; supérieur : 109 / 1 080 × 100 = 10,1 % ; ensemble : 664 / 4 000 × 100 = 16,6 %.

2. Écart absolu : 24,0 − 10,1 = 13,9 points. Écart relatif : 24,0 / 10,1 = 2,38.

3. « Ce tableau présente la prévalence de l'obésité mesurée chez 4 000 adultes de la région selon le diplôme (enquête de l'ORS, 2025). La prévalence diminue régulièrement quand le niveau de diplôme augmente. Elle passe de 24,0 % chez les non-diplômés à 10,1 % chez les diplômés du supérieur, soit 13,9 points d'écart et une fréquence 2,4 fois plus élevée. Ce gradient traduit des inégalités sociales de santé, liées aux revenus, aux conditions de travail, à l'environnement alimentaire et à la littératie ; il justifie de renforcer les actions auprès des moins diplômés. »

4. Le diplôme est stable à l'âge adulte (il ne change plus), il est simple à recueillir et peu refusé dans un questionnaire, contrairement au revenu. Il est aussi lié à la littératie en santé, qui influence la compréhension des messages.

Corrigé – Exercice 2.10

1. Action 1 : avant, écart absolu 41 − 22 = 19 points, écart relatif 41 / 22 = 1,86 ; après, 47 − 34 = 13 points et

47 / 34 = 1,38. Action 2 : avant, 45 − 30 = 15 points et 45 / 30 = 1,50 ; après, 53 − 32 = 21 points et 53 / 32 = 1,66.

2. Action 1 : l'inégalité s'est réduite, en écart absolu et relatif, car le quartier prioritaire a progressé de 12 points (22 à 34 %) contre 6 points ailleurs (41 à 47 %). Action 2 : l'inégalité s'est creusée, car les cadres ont progressé de 8 points (45 à 53 %) et les ouvriers et employés de 2 points seulement (30 à 32 %).

3. Action 1 : universalisme proportionné (action pour tous, renforcée dans le quartier prioritaire). Action 2 : effet « Matthieu » des actions d'information universelles, qui profitent d'abord à ceux qui ont le plus de ressources.

4. Exemples : compléter l'affichage par des dégustations et des recettes de légumes secs à moins de 1 € la portion sur les marchés et dans les entreprises qui emploient beaucoup d'ouvriers ; servir des légumes secs plus souvent dans la restauration collective (cantines, restaurants d'entreprise) ; adapter les supports (pictogrammes, langues, vidéos courtes).

Corrigé – Exercice 2.11

1. Indice comparatif = valeur du territoire / valeur régionale × 100. Mortalité prématurée : A 245 / 190 × 100 = 128,9 ; B 172 / 190 × 100 = 90,5 ; C 214 / 190 × 100 = 112,6. Diabète traité : A 7,1 / 5,4 × 100 = 131,5 ; B 4,8 / 5,4 × 100 = 88,9 ; C 6,0 / 5,4 × 100 = 111,1. Pauvreté : A 21,4 / 14,5 × 100 = 147,6 ; B 11,2 / 14,5 × 100 = 77,2 ; C 16,9 / 14,5 × 100 = 116,6.

2. Classement : A, puis C, puis B. Le territoire A est prioritaire : sa mortalité prématurée est 28,9 % au-dessus de la région, la part de personnes traitées pour un diabète 31,5 % au-dessus, et la pauvreté 47,6 % au-dessus. Les trois indicateurs vont dans le même sens.

3. Le taux brut dépend de la structure par âge : un territoire âgé a mécaniquement plus de décès. Le taux standardisé applique les taux du territoire à une même population de référence ; il permet de comparer des territoires dont les âges diffèrent.

4. Précautions : vérifier les effectifs (petits territoires, d'où des moyennes sur trois ans), la date et la source ; « traité pour un diabète » mesure le recours aux soins et sous-estime les diabètes non diagnostiqués ; l'association entre pauvreté et diabète ne prouve pas à elle seule la cause, mais elle est cohérente avec la littérature.

Corrigé – Exercice 2.12

1. Une offre identique profite d'abord aux familles qui ont le plus de ressources : temps, transport, aisance pour s'inscrire, réseau. Les familles des Glycines viendraient peu (distance, deux bus, pas d'inscription en ligne pour 31 % d'entre elles), alors qu'elles en ont le plus besoin : l'écart se creuserait.

2. L'universalisme proportionné consiste à proposer une action à toute la population, avec une intensité et des modalités proportionnées au niveau de désavantage social. Il a été formulé par Michael Marmot dans le rapport « Fair Society, Healthy Lives » (2010).

3. Exemple : centre et quartiers pavillonnaires, 4 ateliers par an dans chaque secteur, inscription en ligne, participation de 5 € par atelier. Quartier des Glycines, 16 ateliers par an au centre social, au pied des immeubles, sans inscription en ligne (inscription orale au centre social), gratuits, avec garde des jeunes enfants, co-animés par une association de parents ; ingrédients offerts et recettes à emporter.

4. Exemple : 5 500 € pour les Glycines (16 ateliers, ingrédients, garde d'enfants, binôme avec l'association), 3 500 € pour les deux autres secteurs (8 ateliers en tout). Le budget est concentré là où les besoins et les obstacles sont les plus grands, mais tous les secteurs bénéficient de l'action.

5. Indicateurs : part des participants qui habitent les Glycines (objectif : au moins la moitié des participants) ; évolution, dans chaque secteur, de la part des familles qui déclarent cuisiner des légumes au moins 3 fois par semaine, avec calcul de l'écart absolu et relatif entre les Glycines et le centre avant et après.

Partie 3 – Les indicateurs démographiques

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer effectif, proportion, taux et indice ; choisir l'unité adaptée (%, ‰, pour 100 000).
- Lire et interpréter une pyramide des âges.
- Calculer un taux de natalité, un taux de mortalité, un solde naturel et un solde migratoire apparent.
- Calculer et interpréter la part des 65 ans ou plus, l'indice de vieillissement et les rapports de dépendance.
- Définir l'espérance de vie et l'espérance de vie sans incapacité et éviter les erreurs d'interprétation.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Taux brut de natalité = naissances vivantes de l'année / population moyenne de l'année × 1 000.
- Solde naturel = naissances − décès. Solde migratoire apparent = variation de la population − solde naturel.
- Indice de vieillissement = 65 ans ou plus / moins de 20 ans × 100. Rapport de dépendance = (moins de 20 ans + 65 ans ou plus) / 20-64 ans × 100.
- France au 1er janvier 2026 : 69,1 millions d'habitants, 22,2 % de 65 ans ou plus, 22,5 % de moins de 20 ans (Insee, bilan démographique 2025, publié en janvier 2026).
- En 2025 : 645 000 naissances, indicateur conjoncturel de fécondité de 1,56 enfant par femme, solde naturel négatif (environ − 6 000), pour la première fois depuis 1945 (Insee, 2026).
- Espérance de vie à la naissance en 2025 : 85,9 ans pour les femmes et 80,3 ans pour les hommes (Insee, 2026). Espérance de vie sans incapacité à 65 ans en 2024 : 11,8 ans pour les femmes et 10,5 ans pour les hommes (Drees, 2026).

Exercice 2.13 – Effectif, proportion, taux ou indice ? (6 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous relisez le diagnostic rédigé par une autre stagiaire. Elle a utilisé le mot « taux » pour toutes les données. Vous l'aidez à corriger le vocabulaire.

Document 1 – Données relevées dans le diagnostic

a) 128 personnes sont inscrites au portage de repas.

b) 31 % des habitants ont moins de 20 ans.

c) 9,5 naissances pour 1 000 habitants en 2025.

d) 152 personnes de 65 ans ou plus pour 100 personnes de moins de 20 ans.

e) 260 décès par maladies cardio-neurovasculaires pour 100 000 habitants par an.

f) 12 % des enfants de grande section sont en surpoids au bilan de santé.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez un effectif, une proportion et un taux. (3 pts)

2. Indiquez la nature de chaque donnée du document 1 (effectif, proportion, taux, indice). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.14 – Lire deux pyramides des âges (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un réseau de centres sociaux vous demande de présenter, en réunion d'équipe, la différence entre la population d'un quartier récent de la périphérie et celle d'un bourg rural. Vous utilisez deux pyramides simplifiées.

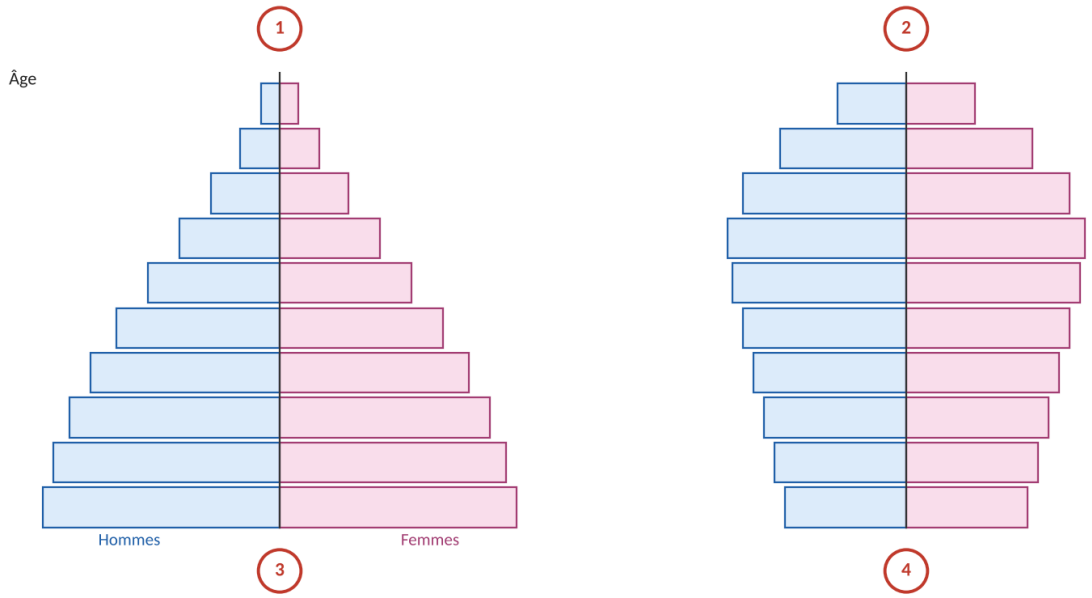


Figure 2.5 – Document 1 – Deux formes de pyramides des âges (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Indiquez ce que représentent l'axe vertical, la partie gauche et la partie droite d'une pyramide. (1,5 pt)
3. Expliquez ce que traduisent une base large, une base qui se rétrécit, un sommet plus large du côté des femmes. (3 pts)
4. Associez chaque pyramide au quartier récent ou au bourg rural et proposez un public prioritaire pour une action nutritionnelle dans chacun. (3,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.15 – Natalité, mortalité et soldes d'une commune (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour le diagnostic du contrat local de santé d'une ville moyenne (données fictives), vous devez décrire la dynamique de la population.

Document 1 – État civil et population de la ville (données fictives, année 2025)

Donnée	Valeur
Population au 1er janvier 2025	52 380
Population au 1er janvier 2026	52 420
Naissances vivantes en 2025	498
Décès en 2025	571

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la population moyenne de l'année. (1 pt)
2. Calculez le taux brut de natalité et le taux brut de mortalité. (3 pts)
3. Calculez le solde naturel et le taux d'accroissement naturel (pour 1 000). (2 pts)
4. Calculez le solde migratoire apparent ; expliquez comment la population a pu augmenter. (3 pts)
5. Comparez avec la situation de la France en 2025 et tirez une conséquence pour les actions de santé. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.16 – Comparer le vieillissement de deux territoires (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie hésite entre deux territoires pour financer un programme de prévention de la dénutrition. Vous comparez leur structure par âge (données fictives).

Document 1 – Population par grand groupe d'âge (données fictives, 1er janvier 2026)

Territoire	Moins de 20 ans	20 à 64 ans	65 ans ou plus
Canton rural du Haut-Val	2 268	6 552	3 780
Ville nouvelle des Coteaux	6 420	12 626	2 354

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la population totale de chaque territoire. (1 pt)
2. Calculez, pour chacun, la part des moins de 20 ans et la part des 65 ans ou plus ; comparez à la France. (3 pts)
3. Calculez l'indice de vieillissement, le rapport de dépendance et le rapport de dépendance des âgés. (4,5 pts)
4. Indiquez le territoire à retenir et justifiez ; précisez pourquoi l'effectif compte aussi. (3,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.17 – Espérance de vie et espérance de vie sans incapacité (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un article de la presse locale, vous lisez : « Avec une espérance de vie de 80 ans, les hommes nés en 2025 vivront jusqu'à 80 ans, et la plupart mourront à cet âge. » Vous êtes chargé de rédiger une réponse pédagogique pour le site du réseau de santé où vous êtes en stage.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez l'espérance de vie à la naissance ; donnez les valeurs de 2025 pour les femmes et pour les hommes, avec la source. (2,5 pts)
2. Relevez les deux erreurs de la phrase de l'article et corrigez-les. (3 pts)
3. Calculez l'écart d'espérance de vie entre femmes et hommes en 2025 et son évolution depuis 2005 (7,1 ans). (1,5 pt)
4. Définissez l'espérance de vie sans incapacité et expliquez en quoi elle justifie la prévention nutritionnelle après 65 ans. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.18 – Choisir un public prioritaire à partir de la démographie (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans une communauté de communes de 24 600 habitants (données fictives). Le service « santé » dispose d'un budget de 6 000 € pour une action de nutrition et hésite entre deux publics : les familles avec de jeunes enfants et les personnes de 75 ans ou plus vivant à domicile. Le directeur vous demande une note de synthèse.

Document 1 – Données démographiques (données fictives, 2025)

Indicateur	Communauté de communes	Département
Naissances dans l'année	196	–
Taux brut de natalité	?	9,8 ‰
Personnes de 75 ans ou plus	3 198	–
Part des 75 ans ou plus	?	10,4 %
Part des 75 ans ou plus vivant seules à domicile	42 %	38 %
Évolution du nombre de 75 ans ou plus en 10 ans	+ 24 %	+ 18 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux brut de natalité et la part des 75 ans ou plus de la communauté de communes (sur la population de 24 600 habitants). (2 pts)
2. Calculez le nombre de personnes de 75 ans ou plus vivant seules. (1 pt)
3. Comparez chaque indicateur au département. (3 pts)
4. Choisissez le public prioritaire et argumentez en trois points. (5 pts)
5. Indiquez deux indicateurs supplémentaires qu'il faudrait connaître avant de décider, avec leur source. (2 pts)
6. Proposez l'action en deux phrases (objectif, modalité). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 2.13

1. Un effectif est un nombre de personnes ou d'événements. Une proportion est une partie d'un tout rapportée à ce tout (entre 0 et 1, ou entre 0 et 100 %), sans notion de durée. Un taux rapporte des événements survenus pendant une période à la population exposée pendant cette période, souvent pour 1 000 ou pour 100 000 habitants.
2. a) Effectif. b) Proportion. c) Taux (taux brut de natalité). d) Indice (indice de vieillissement : un rapport entre deux groupes distincts, ce n'est pas une proportion). e) Taux (taux de mortalité par cause). f) Proportion (prévalence du surpoids, mesurée à un moment donné).

Corrigé – Exercice 2.14

1. Légendes : 1 Pyramide en triangle : population jeune ; 2 Pyramide en meule ou en toupie : population vieillissante ; 3 Natalité élevée, espérance de vie plus courte ; 4 Natalité basse, espérance de vie longue.
2. L'axe vertical représente les groupes d'âge, du plus jeune en bas au plus âgé en haut. À gauche figurent les hommes, à droite les femmes, en effectif ou en pourcentage de la population totale.
3. Une base large traduit une natalité élevée (beaucoup d'enfants). Une base qui se rétrécit traduit une baisse de la natalité. Un sommet plus large du côté des femmes traduit la surmortalité masculine : les femmes vivent plus longtemps.
4. La pyramide en triangle correspond au quartier récent, où s'installent de jeunes familles : public prioritaire, les parents de jeunes enfants (1000 premiers jours, diversification, goûters). La pyramide en meule correspond au bourg rural : public prioritaire, les personnes âgées à domicile (prévention de la dénutrition, repas partagés, portage).

Corrigé – Exercice 2.15

1. Population moyenne = (52 380 + 52 420) / 2 = 52 400 habitants.
2. Taux brut de natalité = 498 / 52 400 × 1 000 = 9,50 ‰. Taux brut de mortalité = 571 / 52 400 × 1 000 = 10,90 ‰.
3. Solde naturel = 498 − 571 = − 73. Taux d'accroissement naturel = − 73 / 52 400 × 1 000 = − 1,39 ‰.
4. Variation de la population = 52 420 − 52 380 = + 40. Solde migratoire apparent = 40 − (− 73) = + 113. La population augmente parce que les arrivées dépassent les départs de 113 personnes, ce qui compense le solde naturel négatif.
5. En France en 2025, le solde naturel est aussi négatif (environ − 6 000, Insee, 2026) et la natalité est d'environ 9,3 ‰ (645 000 naissances pour 69,1 millions d'habitants). La ville suit la même tendance : plus de décès que de naissances, donc une population qui vieillit. Il faut renforcer les actions pour les personnes âgées (dénutrition, perte d'autonomie) sans oublier les familles qui arrivent dans la ville.

Corrigé – Exercice 2.16

1. Haut-Val : 2 268 + 6 552 + 3 780 = 12 600 habitants. Les Coteaux : 6 420 + 12 626 + 2 354 = 21 400 habitants.
2. Haut-Val : moins de 20 ans 2 268 / 12 600 × 100 = 18,0 % ; 65 ans ou plus 3 780 / 12 600 × 100 = 30,0 %. Les Coteaux : moins de 20 ans 6 420 / 21 400 × 100 = 30,0 % ; 65 ans ou plus 2 354 / 21 400 × 100 = 11,0 %. France : 22,5 % et 22,2 % (Insee, 1er janvier 2026). Le Haut-Val est beaucoup plus âgé que la France, les Coteaux beaucoup plus jeunes.
3. Indice de vieillissement : Haut-Val 3 780 / 2 268 × 100 = 166,7 ; Coteaux 2 354 / 6 420 × 100 = 36,7. Rapport de dépendance : Haut-Val (2 268 + 3 780) / 6 552 × 100 = 92,3 ; Coteaux (6 420 + 2 354) / 12 626 × 100 = 69,5. Rapport de dépendance des âgés : Haut-Val 3 780 / 6 552 × 100 = 57,7 ; Coteaux 2 354 / 12

626 × 100 = 18,6.

4. Le Haut-Val est prioritaire : 30 % de 65 ans ou plus, 167 seniors pour 100 jeunes, et près de 58 personnes âgées pour 100 personnes d'âge actif, donc moins d'aidants potentiels. L'effectif compte aussi : les Coteaux comptent 2 354 personnes de 65 ans ou plus, soit moins que le Haut-Val (3 780) ; si les effectifs avaient été proches, un territoire jeune aurait pu avoir autant de personnes à toucher. Il faut toujours regarder la proportion et l'effectif.

Corrigé – Exercice 2.17

1. L'espérance de vie à la naissance est le nombre moyen d'années que vivrait une génération fictive soumise toute sa vie aux taux de mortalité par âge de l'année considérée. En 2025 : 85,9 ans pour les femmes et 80,3 ans pour les hommes (Insee, bilan démographique publié en janvier 2026).

2. Première erreur : ce n'est pas une prévision pour les bébés nés en 2025, c'est une photographie des conditions de mortalité de l'année ; si la mortalité continue de baisser, ils vivront en moyenne plus longtemps. Deuxième erreur : c'est une moyenne, pas l'âge auquel la plupart des personnes meurent ; les décès se répartissent sur tous les âges, et l'âge le plus fréquent au décès est plus élevé que la moyenne.

3. Écart en 2025 : 85,9 − 80,3 = 5,6 ans. En 2005, l'écart était de 7,1 ans : il s'est réduit de 7,1 − 5,6 = 1,5 an.

4. L'espérance de vie sans incapacité est le nombre moyen d'années vécues sans limitation dans les activités de la vie quotidienne. À 65 ans, elle est de 11,8 ans pour les femmes et 10,5 ans pour les hommes (Drees, 2026, données 2024). Une partie des années gagnées est vécue avec une incapacité ; la dénutrition et la sarcopénie font partie des causes de perte d'autonomie que l'on peut prévenir (apports en protéines, activité physique, repas partagés).

Corrigé – Exercice 2.18

1. Taux brut de natalité = 196 / 24 600 × 1 000 = 7,97 ‰. Part des 75 ans ou plus = 3 198 / 24 600 × 100 = 13,0 %.

2. Personnes de 75 ans ou plus vivant seules = 3 198 × 0,42 = 1 343 personnes environ.

3. Natalité : 7,97 ‰ contre 9,8 ‰ dans le département, plus basse. Part des 75 ans ou plus : 13,0 % contre 10,4 %, soit 2,6 points de plus. Personnes âgées vivant seules : 42 % contre 38 %, soit 4 points de plus. Évolution : + 24 % en 10 ans contre + 18 %, un vieillissement plus rapide.

4. Public prioritaire : les personnes de 75 ans ou plus à domicile. Arguments : elles sont proportionnellement plus nombreuses que dans le département et leur nombre augmente plus vite ; plus de 1 300 d'entre elles vivent seules, ce qui augmente le risque de dénutrition (repas sautés, perte d'appétit, difficulté à faire les courses) ; la dénutrition touche environ 10 % des personnes âgées à domicile (HAS) et accélère la perte d'autonomie, avec un coût humain et financier élevé.

5. Indicateurs utiles : nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile (conseil départemental) ; nombre de personnes inscrites au portage de repas (CCAS, CIAS) ; taux d'hospitalisation des 75 ans ou plus (PMSI, ORS) ; part des 75 ans ou plus sous le seuil de pauvreté (Insee).

6. Exemple : « Réduire le risque de dénutrition des personnes de 75 ans ou plus vivant seules à domicile. Nous proposons des repas partagés mensuels dans trois communes, avec une pesée volontaire, un repérage simple et une orientation vers le médecin traitant, en partenariat avec le CIAS et les clubs d'aînés. »

Partie 4 – Mortalité, morbidité et standardisation

Objectifs – Objectifs de la partie

- Calculer un taux brut de mortalité, un taux spécifique par âge ou par cause, un taux de mortalité infantile, une part de mortalité prématurée.
- Expliquer pourquoi on standardise ; appliquer la méthode directe et la méthode indirecte (rapport standardisé de mortalité).
- Distinguer prévalence et incidence ; utiliser la relation prévalence = incidence × durée.
- Comparer deux territoires et en tirer une conclusion argumentée et prudente.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Taux brut de mortalité = décès de l'année / population moyenne × 1 000. Taux par cause : × 100 000.
- Mortalité infantile = décès avant 1 an / naissances vivantes × 1 000 (environ 4 ‰ en France). Mortalité prématurée : décès avant 65 ans.
- Méthode directe : taux spécifiques du territoire × population de référence = décès attendus, puis taux standardisé.
- Méthode indirecte : taux spécifiques de la référence × population du territoire = décès attendus ; rapport standardisé de mortalité (RSM) = décès observés / décès attendus ; indice comparatif = RSM × 100.
- Prévalence = cas existants / population à un moment. Incidence = nouveaux cas pendant une période / population à risque au début de la période. En situation stable, prévalence ≈ incidence × durée moyenne de la maladie.
- France 2024 : 641 046 décès ; taux standardisé de 777,9 pour 100 000 ; tumeurs 27,1 % des décès, maladies cardio-neurovasculaires 21,2 % (Drees, Inserm-CépiDc, Santé publique France, juin 2026).

Exercice 2.19 – Calculer des taux de mortalité (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le pays de Lisle (communauté de communes fictive de 31 200 habitants) prépare son contrat local de santé. Vous calculez les premiers indicateurs de mortalité pour l'année 2025.

Document 1 – Données de mortalité du pays de Lisle (données fictives, 2025)

Donnée	Valeur
Population moyenne	31 200
dont 65 ans ou plus	8 112
Décès de l'année	352
dont décès de personnes de 65 ans ou plus	296
Décès par tumeurs	98
Décès par maladies cardio-neurovasculaires	81
Naissances vivantes de 2023 à 2025	860
Décès avant 1 an de 2023 à 2025	6

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux brut de mortalité. (1 pt)
2. Calculez le taux spécifique de mortalité des 65 ans ou plus et celui des moins de 65 ans. (2,5 pts)
3. Calculez la part de la mortalité prématurée dans l'ensemble des décès. (1,5 pt)
4. Calculez les taux de mortalité par tumeurs et par maladies cardio-neurovasculaires pour 100 000 habitants. (2 pts)
5. Calculez le taux de mortalité infantile sur trois ans ; expliquez pourquoi on regroupe trois années. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.20 – Légender les deux méthodes de standardisation (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une fiche de révision pour votre groupe de BTS. Vous voulez un schéma qui compare la méthode directe et la méthode indirecte.

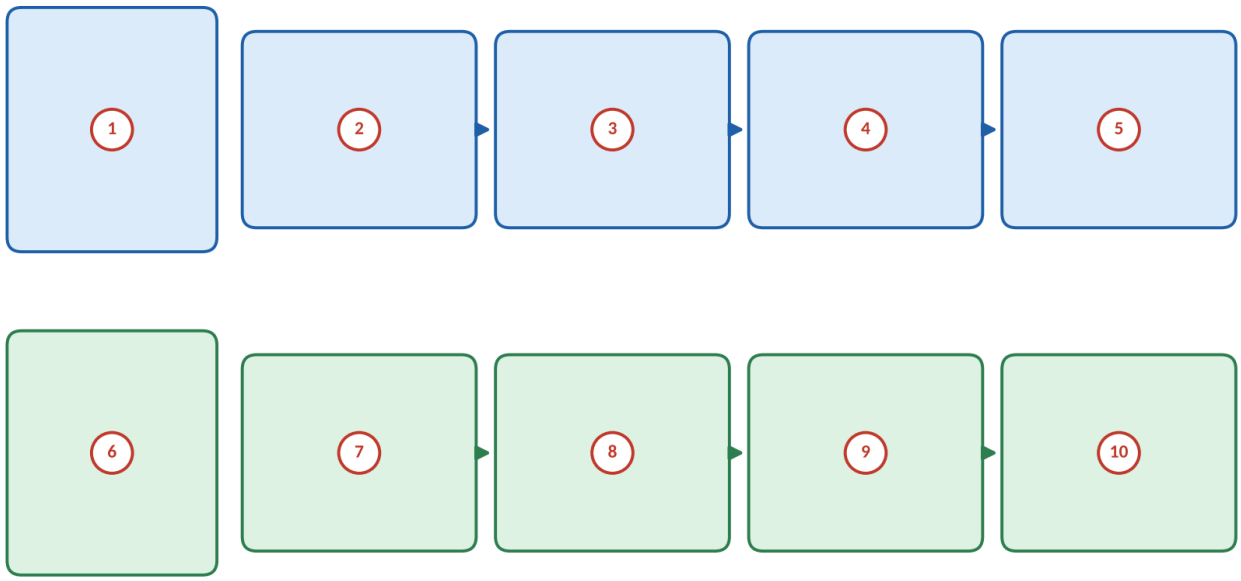


Figure 2.6 – Document 1 – Méthode directe et méthode indirecte (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (5 pts)

2. Indiquez dans quel cas on préfère la méthode indirecte. (1,5 pt)

3. Expliquez ce que signifie un rapport standardisé de mortalité de 1,20. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.21 – Standardisation directe : deux communes (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un élu de Saint-Aubin s'inquiète : « Notre taux de mortalité est bien plus élevé que celui de Belcourt, notre population est en moins bonne santé. » Vous vérifiez son affirmation (données fictives, moyenne annuelle 2023-2025).

Document 1 – Population et décès par âge

Âge	Saint-Aubin population	Saint-Aubin décès	Belcourt population	Belcourt décès	Population de référence
0 à 44 ans	3 600	5	6 300	10	55 000
45 à 74 ans	3 000	33	2 900	38	35 000
75 ans ou plus	1 400	98	800	62	10 000
Total	8 000	136	10 000	110	100 000

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux brut de mortalité de chaque commune. (2 pts)

2. Calculez les taux spécifiques par âge (pour 1 000) de chaque commune. (3 pts)

3. Calculez le nombre de décès attendus dans la population de référence pour chaque commune. (3 pts)

4. Calculez le taux standardisé de chaque commune. (2 pts)

5. Répondez à l'élu en expliquant l'écart entre taux bruts et taux standardisés. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.22 – Méthode indirecte : un petit quartier (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le quartier de la Fontaine (4 900 habitants, données fictives) compte trop peu de décès pour calculer des taux par âge fiables. L'ORS vous fournit les taux spécifiques du département et vous demande un rapport standardisé de mortalité sur trois ans (moyenne annuelle).

Document 1 – Données (fictives, moyenne annuelle 2023-2025)

Âge	Population du quartier	Taux spécifique du département (‰)
0 à 44 ans	3 100	1,2
45 à 74 ans	1 500	9,5
75 ans ou plus	300	68,0
Décès observés dans le quartier (moyenne annuelle)	47	

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi la méthode directe n'est pas adaptée ici. (2 pts)
2. Calculez le nombre de décès attendus dans le quartier, par âge puis au total. (4 pts)
3. Calculez le rapport standardisé de mortalité et l'indice comparatif de mortalité. (2 pts)
4. Interprétez le résultat et indiquez le nombre de décès « en excès » chaque année. (2 pts)
5. Indiquez une limite de ce calcul. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.23 – Prévalence et incidence du diabète (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans une maison de santé pluriprofessionnelle qui suit les habitants d'une commune de 18 500 habitants (données fictives). Le médecin coordinateur vous transmet les données du diabète traité.

Document 1 – Diabète traité (données fictives, année 2025)

- Personnes traitées pour un diabète au 1er janvier 2025 : 1 054.
- Personnes qui ont commencé un traitement pour un diabète en 2025 (non traitées au 1er janvier) : 87.
- Durée moyenne de vie avec un diabète de type 2 après le diagnostic, retenue pour l'exercice : 12 ans.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez la prévalence et l'incidence. (2 pts)
2. Calculez la prévalence au 1er janvier 2025 et l'incidence cumulée de l'année (pour 1 000 personnes à risque). (4 pts)
3. Vérifiez la cohérence de vos résultats avec la relation prévalence ≈ incidence × durée. (2 pts)
4. Expliquez l'effet attendu, sur l'incidence et sur la prévalence, d'une action de prévention primaire et d'un meilleur dépistage. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.24 – Comparer deux territoires pour choisir où agir (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une délégation départementale d'agence régionale de santé (fictive) finance un programme de prévention cardio-vasculaire par la nutrition dans une seule communauté de communes. Un chargé de mission affirme : « Il faut choisir Rives-de-l'Ain : c'est là que le taux de mortalité est le plus élevé. » Vous êtes chargé d'une note contradictoire.

Document 1 – Indicateurs (données fictives, moyennes annuelles 2021-2023)

Indicateur	Rives-de-l'Ain	Plateau-Nord	Région
Taux brut de mortalité (‰)	12,4	9,1	9,8
Taux standardisé de mortalité (‰)	8,9	10,2	9,3
Taux standardisé de mortalité prématurée (‰)	2,21	2,88	2,10
Part des 75 ans ou plus (%)	15,8	8,7	10,6
Part de la population traitée pour hypertension (%)	15,2	12,9	13,4

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi le taux brut de Rives-de-l'Ain est élevé. (2 pts)
2. Calculez l'indice comparatif (base 100 = région) des taux standardisés de mortalité et de mortalité prématurée pour les deux territoires. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi la part de personnes traitées pour hypertension est plus élevée à Rives-de-l'Ain et pourquoi elle ne suffit pas à conclure. (3 pts)
4. Rédigez la note contradictoire (8 à 10 lignes) qui recommande un territoire. (5 pts)
5. Indiquez deux données complémentaires à demander à l'ORS. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 2.19

1. Taux brut de mortalité = 352 / 31 200 × 1 000 = 11,28 ‰.
2. 65 ans ou plus : 296 / 8 112 × 1 000 = 36,49 ‰. Moins de 65 ans : décès 352 − 296 = 56 ; population 31 200 − 8 112 = 23 088 ; taux 56 / 23 088 × 1 000 = 2,43 ‰.
3. Part de la mortalité prématurée = 56 / 352 × 100 = 15,9 % des décès surviennent avant 65 ans.
4. Tumeurs : 98 / 31 200 × 100 000 = 314,1 pour 100 000. Maladies cardio-neurovasculaires : 81 / 31 200 × 100 000 = 259,6 pour 100 000.
5. Mortalité infantile = 6 / 860 × 1 000 = 6,98 ‰ sur 2023-2025. Avec environ 287 naissances par an, un seul décès de plus ou de moins change beaucoup le taux annuel : on regroupe trois années pour avoir un indicateur plus stable. Le résultat est supérieur à la moyenne française (environ 4 ‰), mais il repose sur 6 décès seulement : il faut l'interpréter avec prudence.

Corrigé – Exercice 2.20

1. Légendes : 1 Méthode directe ; 2 Taux spécifiques par âge du territoire étudié ; 3 × population de référence (même structure d'âge pour tous) ; 4 = décès attendus dans la population de référence ; 5 Taux standardisé = décès attendus / population de référence ; 6 Méthode indirecte ; 7 Taux spécifiques par âge de la population de référence ; 8 × population du territoire étudié, par âge ; 9 = décès attendus dans le territoire ; 10 Rapport standardisé de mortalité = décès observés / décès attendus.
2. On préfère la méthode indirecte pour les petits territoires (quartier, petite commune), quand les décès par âge sont trop peu nombreux pour calculer des taux spécifiques fiables.
3. Un RSM de 1,20 signifie que le territoire a 20 % de décès en plus que ce qu'on attendrait s'il avait la mortalité par âge de la référence (indice comparatif de 120).

Corrigé – Exercice 2.21

1. Taux bruts : Saint-Aubin 136 / 8 000 × 1 000 = 17,00 ‰ ; Belcourt 110 / 10 000 × 1 000 = 11,00 ‰.
2. Taux spécifiques. Saint-Aubin : 5 / 3 600 × 1 000 = 1,39 ‰ ; 33 / 3 000 × 1 000 = 11,00 ‰ ; 98 / 1 400 × 1 000 = 70,00 ‰. Belcourt : 10 / 6 300 × 1 000 = 1,59 ‰ ; 38 / 2 900 × 1 000 = 13,10 ‰ ; 62 / 800 × 1 000 = 77,50 ‰.
3. Décès attendus dans la population de référence. Saint-Aubin : 55 000 × 1,39 / 1 000 + 35 000 × 11,00 / 1 000 + 10 000 × 70,00 / 1 000 = 76,4 + 385,0 + 700,0 = 1 161,4. Belcourt : 55 000 × 1,59 / 1 000 + 35 000 × 13,10 / 1 000 + 10 000 × 77,50 / 1 000 = 87,3 + 458,6 + 775,0 = 1 320,9. (Calcul fait avec les taux non arrondis.)
4. Taux standardisés : Saint-Aubin 1 161,4 / 100 000 × 1 000 = 11,61 ‰ ; Belcourt 1 320,9 / 100 000 × 1 000 = 13,21 ‰.
5. « Votre taux brut est plus élevé parce que Saint-Aubin compte beaucoup de personnes âgées : 17,5 % de 75 ans ou plus (1 400 sur 8 000) contre 8,0 % à Belcourt. À structure d'âge identique, la mortalité de Saint-Aubin (11,61 ‰) est inférieure à celle de Belcourt (13,21 ‰). Dans chaque groupe d'âge, Belcourt a d'ailleurs une mortalité plus forte. Ce n'est donc pas la population de Saint-Aubin qui est en moins bonne santé ; elle est surtout plus âgée. » On ne compare jamais deux territoires avec des taux bruts.

Corrigé – Exercice 2.22

1. Le quartier compte 47 décès par an environ, répartis en trois groupes d'âge : les taux spécifiques du quartier seraient très instables (quelques décès de plus ou de moins les changeraient beaucoup). La méthode indirecte n'utilise que le total des décès observés du quartier.
2. Décès attendus = population du quartier × taux du département / 1 000. 0 à 44 ans : 3 100 × 1,2 / 1 000 =

3,72 ; 45 à 74 ans : 1 500 × 9,5 / 1 000 = 14,25 ; 75 ans ou plus : 300 × 68,0 / 1 000 = 20,40. Total : 3,72 + 14,25 + 20,40 = 38,37 décès attendus.

3. RSM = 47 / 38,37 = 1,225. Indice comparatif de mortalité = 1,225 × 100 = 122,5.

4. Le quartier a une mortalité supérieure de 22,5 % à celle du département, à âge égal. Cela représente 47 − 38,37 = 8,6 décès en excès chaque année. C'est un argument fort pour un diagnostic approfondi et des actions de prévention dans ce quartier.

5. Limites : 47 décès restent un petit nombre, il faut calculer un intervalle de confiance ou un test avant de conclure ; le RSM ne permet de comparer le quartier qu'à sa référence, et pas deux quartiers entre eux ; il ne dit rien des causes de décès.

Corrigé – Exercice 2.23

1. La prévalence est la proportion de personnes atteintes (cas existants) dans une population à un moment donné. L'incidence est la proportion de nouveaux cas apparus pendant une période parmi les personnes à risque (non malades) au début de la période.

2. Prévalence = 1 054 / 18 500 × 100 = 5,70 %. Population à risque = 18 500 − 1 054 = 17 446. Incidence cumulée = 87 / 17 446 × 1 000 = 4,99 pour 1 000 personnes à risque en 2025.

3. Incidence × durée ≈ 5 / 1 000 × 12 = 0,060, soit environ 6,0 %, proche de la prévalence observée (5,70 %). Les résultats sont cohérents.

4. La prévention primaire (alimentation, activité physique, perte de poids chez les personnes à risque) réduit l'incidence, donc, à terme, la prévalence. Un meilleur dépistage augmente d'abord l'incidence observée et la prévalence (on découvre des diabètes ignorés) ; ce n'est pas une aggravation, mais une meilleure connaissance de la situation, qui permet de prévenir les complications.

Corrigé – Exercice 2.24

1. Rives-de-l'Ain compte beaucoup de personnes âgées (15,8 % de 75 ans ou plus contre 10,6 % dans la région) : le nombre de décès est donc mécaniquement plus élevé, ce qui augmente le taux brut.

2. Indice comparatif = taux du territoire / taux de la région × 100. Mortalité standardisée : Rives-de-l'Ain 8,9 / 9,3 × 100 = 95,7 ; Plateau-Nord 10,2 / 9,3 × 100 = 109,7. Mortalité prématurée : Rives-de-l'Ain 2,21 / 2,10 × 100 = 105,2 ; Plateau-Nord 2,88 / 2,10 × 100 = 137,1.

3. L'hypertension est plus fréquente avec l'âge : la part plus élevée à Rives-de-l'Ain reflète surtout sa population âgée (c'est une donnée brute, non standardisée). Elle mesure aussi le recours aux soins : dans un territoire où l'on consulte moins, des hypertensions ne sont pas traitées et la part peut être faible alors que le problème est réel.

4. Exemple : « Le taux brut de mortalité de Rives-de-l'Ain (12,4 ‰) est élevé parce que sa population est âgée. À âge égal, sa mortalité est inférieure de 4,3 % à la moyenne régionale (indice 95,7). À l'inverse, Plateau-Nord a une mortalité standardisée supérieure de 9,7 % à la région et surtout une mortalité prématurée supérieure de 37,1 % (2,88 ‰ contre 2,10 ‰). Cette mortalité avant 65 ans est en partie évitable par la prévention, en particulier cardio-vasculaire (alimentation, sel, activité physique, tabac). Nous recommandons donc Plateau-Nord. La part plus faible de personnes traitées pour hypertension y fait craindre un défaut de dépistage, que le programme devra aussi traiter. »

5. Données utiles : mortalité prématurée par cause (maladies cardio-neurovasculaires) en taux standardisé ; indicateurs sociaux (taux de pauvreté, part d'ouvriers) ; densité de médecins généralistes ; part de personnes traitées pour hypertension standardisée sur l'âge.

Partie 5 – Sources de données, portrait de territoire et état nutritionnel

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les principales sources de données de santé et savoir laquelle consulter pour une question donnée.
- Calculer et classer un IMC, interpréter un tour de taille, calculer des prévalences de maigreur, de surpoids et d'obésité.
- Distinguer données mesurées et données déclarées ; estimer la précision d'une prévalence (marge d'erreur).
- Construire un portrait de santé de territoire et rédiger des constats sourcés et datés.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Insee : population, âges, revenus, pauvreté (Filosofi), diplômes. Drees : état de santé, santé scolaire, espérance de vie sans incapacité. Inserm-CépiDc : causes de décès. Assurance maladie : ALD, pathologies traitées (data.ameli.fr). Santé publique France : Géodes, Esteban, Baromètre. ANSES : INCA 3, Ciqual, Oqali (avec INRAE). ORS : diagnostics locaux, Score-santé.
- IMC = poids (kg) / taille² (m²). Maigreur < 18,5 ; normal 18,5 à 24,9 ; surpoids 25 à 29,9 ; obésité ≥ 30 (OMS).
- Tour de taille : risque accru à partir de 94 cm (homme) ou 80 cm (femme), risque élevé à partir de 102 cm ou 88 cm.
- Esteban 2015 (mesures) : 49 % des adultes de 18 à 74 ans en surpoids, dont 17 % en obésité ; 17 % des 6-17 ans en surpoids, dont 4 % en obésité (Santé publique France).
- Marge d'erreur d'une proportion (niveau de confiance 95 %) = 1,96 × √(p × (1 − p) / n).
- Les données déclarées sous-estiment le poids et surestiment la taille, donc sous-estiment le surpoids.

Exercice 2.25 – Légender la carte des sources de données (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous commencez votre stage dans un pôle de santé d'une petite ville. Votre tutrice vous demande d'établir la liste des sources que vous utiliserez pour le portrait de santé du territoire.

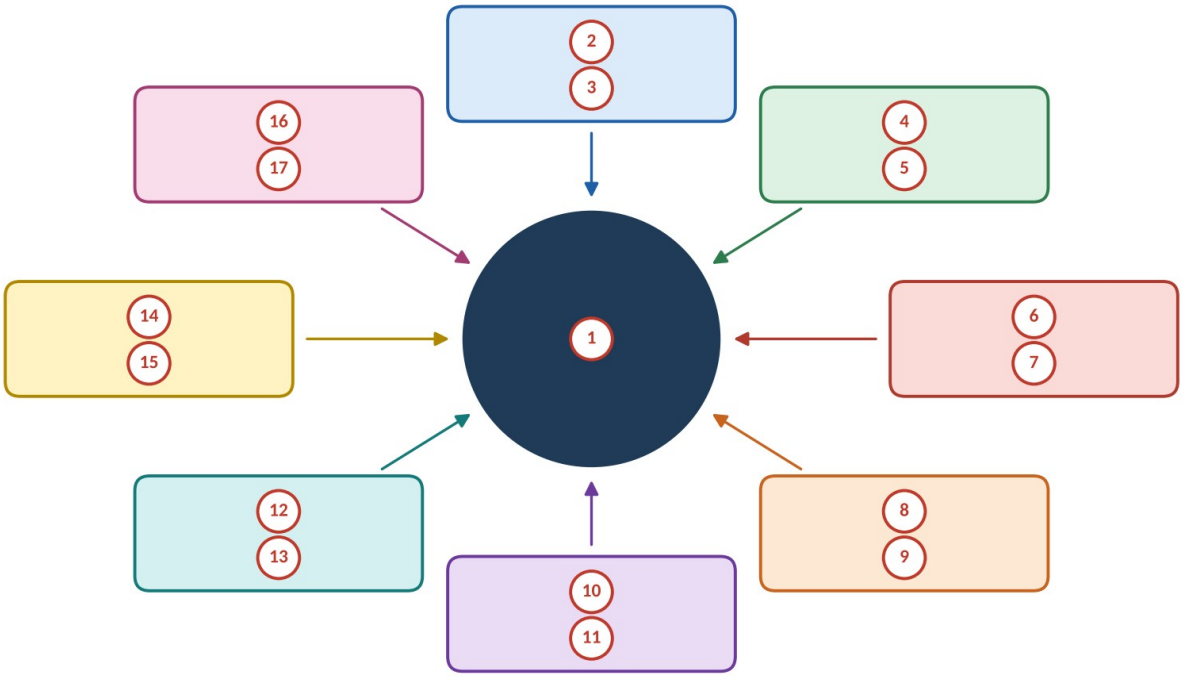


Figure 2.7 – Document 1 – Les sources d'un portrait de santé de territoire (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 17 du document 1. (8,5 pts)
2. Expliquez pourquoi le recueil local (élément 16) reste indispensable même quand les données nationales existent. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.26 – Trouver la bonne source (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le comité de pilotage d'un projet de santé vous pose huit questions. Pour chacune, vous devez indiquer où trouver la réponse.

Document 1 – Les questions du comité

a) Combien d'habitants de la commune vivent sous le seuil de pauvreté ?

b) Combien de personnes de la commune sont prises en charge pour un diabète ?

c) Quelles sont les causes de décès les plus fréquentes dans le département ?

d) Quelle est la teneur en fibres des lentilles vertes cuites ?

e) Quelle part des adultes français déclare pratiquer une activité physique régulière ?

f) Quelle est la consommation moyenne de légumineuses des adultes en France ?

g) Combien d'enfants de grande section de la commune sont en surpoids ?

h) Les habitants du quartier jugent-ils les fruits et légumes trop chers au marché ?

À vous de jouer – Questions

1. Associez à chaque question une source précise (organisme et enquête ou base). (8 pts)

2. Indiquez pour quelles questions une donnée locale est indispensable et comment l'obtenir. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.27 – IMC et prévalences mesurées (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre d'une journée de prévention organisée par une mutuelle (données fictives), 320 adultes volontaires ont été pesés et mesurés. Vous calculez d'abord quelques IMC individuels pour vérifier la saisie, puis les prévalences.

Document 1 – Six fiches tirées au hasard

Personne	Poids (kg)	Taille (m)
A	58	1,62
B	91	1,75
C	104	1,68
D	49	1,66
E	77	1,80
F	82	1,58

Document 2 – Résultats des 320 adultes

Maigreur : 9 personnes ; surpoids hors obésité : 98 personnes ; obésité : 61 personnes ; les autres ont un IMC normal.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'IMC des six personnes du document 1 et classez-les selon les seuils de l'OMS. (4,5 pts)
2. Calculez, à partir du document 2, la prévalence de la maigreur, du surpoids hors obésité, de l'obésité, du surpoids obésité comprise et de la corpulence normale. (4 pts)
3. Comparez aux données Esteban 2015 et indiquez pourquoi cette comparaison est fragile. (3,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.28 – Mesuré ou déclaré, adulte ou enfant (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous lisez trois rapports qui donnent des prévalences d'obésité différentes et un dossier de santé au travail qui contient des tours de taille. Vous devez expliquer les écarts à votre tutrice.

Document 1 – Trois chiffres

- Esteban (Santé publique France), mesures réalisées en 2015 : 17 % des adultes de 18 à 74 ans sont obèses.
- Étude OFÉO (2024), poids et taille déclarés : 18,1 % des adultes déclarent un IMC ≥ 30.
- Un journal titre : « L'obésité a augmenté de 1,1 point en 9 ans. »

Document 2 – Tours de taille relevés en santé au travail

Salarié	Sexe	Tour de taille (cm)
1	Homme	91
2	Femme	84
3	Homme	105
4	Femme	92
5	Homme	97

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi la conclusion du journal est méthodologiquement fausse. (3 pts)
2. Indiquez dans quel sens les données déclarées biaisent la prévalence de l'obésité. (1,5 pt)
3. Classez les cinq salariés du document 2 selon le risque lié au tour de taille. (2,5 pts)
4. Expliquez pourquoi on n'utilise pas les seuils de l'adulte chez l'enfant et citez les références utilisées en France. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.29 – La précision d'une prévalence (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Reprenez les données de l'exercice 2.27 : 61 adultes obèses sur 320. La mutuelle veut savoir si elle peut annoncer « 19 % d'obésité chez nos adhérents ». Elle hésite aussi pour sa prochaine journée entre un échantillon de 80 personnes et un échantillon de 1 280 personnes.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la prévalence de l'obésité avec deux décimales. (1 pt)
2. Calculez la marge d'erreur et l'intervalle de confiance à 95 % pour n = 320. (3 pts)
3. Calculez la marge d'erreur si la même prévalence avait été observée sur 80 personnes, puis pour une prévalence de 19 % sur 1 280 personnes. (3 pts)
4. Concluez : de combien faut-il multiplier l'effectif pour diviser la marge d'erreur par deux ? (2 pts)
5. Indiquez pourquoi, même avec un grand échantillon, ce résultat ne décrit pas l'ensemble des adhérents. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.30 – Construire le portrait de santé d'un quartier (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au centre social du quartier du Moulin (données fictives), dans une commune de 31 000 habitants. Le centre social veut déposer un dossier de financement pour une action « alimentation des familles » et vous demande le portrait de santé du quartier.

Document 1 – Données rassemblées (fictives sauf la colonne France)

Indicateur	Quartier du Moulin	Commune	France
Population	5 600	31 000	69,1 millions (Insee, 2026)
Moins de 18 ans	1 624	6 150	–
65 ans ou plus	840	7 440	22,2 % (Insee, 2026)
Familles avec enfants	588	4 250	–
dont familles monoparentales	196	722	–
Taux de pauvreté	36 %	13 %	14 à 15 % (Insee)
Enfants de CE1 examinés au bilan de santé	112	–	–
dont enfants en surpoids (obésité comprise)	19	11,2 % (département)	–

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour le quartier et la commune, la part des moins de 18 ans, la part des 65 ans ou plus et la part des familles monoparentales. (4,5 pts)
2. Calculez la prévalence du surpoids des enfants de CE1 du quartier et l'écart avec le département. (2 pts)
3. Calculez l'écart absolu et l'écart relatif du taux de pauvreté entre le quartier et la commune. (1,5 pt)
4. Rédigez quatre constats sourcés et datés. (6 pts)
5. Concluez sur le public prioritaire et sur deux déterminants à prendre en compte. (2 pts)
6. Indiquez deux limites de ce portrait. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 2.25

1. Légendes : 1 Portrait de santé du territoire ; 2 Insee ; 3 population, âge, revenus, pauvreté, diplômes ; 4 Drees ; 5 santé scolaire, état de santé, établissements ; 6 Inserm-CépiDc ; 7 causes médicales de décès ; 8 Assurance maladie (SNDS) ; 9 remboursements, maladies traitées ; 10 Santé publique France ; 11 Géodes, enquêtes Esteban, Baromètre ; 12 ANSES ; 13 INCA 3, table Ciqual, Oqali ; 14 Observatoire régional de la santé ; 15 tableaux de bord, diagnostics locaux ; 16 Recueil local ; 17 questionnaires, entretiens, observation.
2. Les données nationales et départementales ne décrivent pas un quartier précis ni un public précis ; elles ne disent rien des besoins ressentis et exprimés, des habitudes, des contraintes ni des ressources locales. Le recueil local (questionnaire, entretiens, observation) apporte ces informations et associe les habitants au diagnostic.

Corrigé – Exercice 2.26

1. a) Insee, dispositif Filosofi (statistiques locales). b) Assurance maladie, data.ameli.fr (pathologies traitées, ALD), ou ORS. c) Inserm-CépiDc, ou indicateurs de l'ORS et Géodes de Santé publique France. d) ANSES, table Ciqual 2025. e) Santé publique France, Baromètre de Santé publique France (40,2 % des adultes déclarent une pratique régulière en 2024). f) ANSES, enquête INCA 3 (2014-2015). g) Bilans de santé scolaire de l'Éducation nationale (service de santé scolaire, données agrégées). h) Recueil local : questionnaire ou entretiens auprès des habitants, observation du marché.
2. Une donnée locale est indispensable pour les questions a, b, g et h. Les questions a et b ont une réponse publiée à l'échelle communale. La question g demande les bilans de santé scolaire, sur demande au médecin ou à l'infirmière de l'Éducation nationale. La question h ne peut être renseignée que par un recueil fait par le stagiaire.

Corrigé – Exercice 2.27

1. IMC = poids / taille². A : 58 / 1,62² = 22,1, corpulence normale. B : 91 / 1,75² = 29,7, surpoids. C : 104 / 1,68² = 36,8, obésité de classe II (35 à 39,9). D : 49 / 1,66² = 17,8, maigreur. E : 77 / 1,80² = 23,8, corpulence normale. F : 82 / 1,58² = 32,8, obésité de classe I (30 à 34,9).
2. Corpulence normale : 320 − 9 − 98 − 61 = 152 personnes. Maigreur : 9 / 320 × 100 = 2,8 % ; surpoids hors obésité : 98 / 320 × 100 = 30,6 % ; obésité : 61 / 320 × 100 = 19,1 % ; surpoids obésité comprise : (98 + 61) / 320 × 100 = 159 / 320 × 100 = 49,7 % ; normale : 152 / 320 × 100 = 47,5 %.
3. Les valeurs sont proches d'Esteban 2015 (49 % de surpoids, dont 17 % d'obésité, chez les 18-74 ans). La comparaison est fragile : les participants sont des volontaires (biais de sélection, les personnes préoccupées par leur poids viennent peut-être plus), les âges ne sont pas forcément les mêmes (pas de standardisation), l'effectif est petit (marge d'erreur d'environ 4 points, voir exercice 2.29) et les données nationales datent de 2015.

Corrigé – Exercice 2.28

1. Le journal compare 17 % (mesures, 2015) et 18,1 % (déclarations, 2024). Les méthodes sont différentes : les données déclarées sous-estiment l'obésité. L'écart réel est donc probablement plus grand que 1,1 point, mais on ne peut pas le calculer ainsi. On ne compare que des données recueillies avec la même méthode.
2. Les personnes sous-estiment leur poids et surestiment leur taille : l'IMC déclaré est plus faible, la prévalence de l'obésité est sous-estimée.
3. Salarié 1 (homme, 91 cm) : pas de risque accru (moins de 94 cm). Salariée 2 (femme, 84 cm) : risque accru (80 à 87 cm). Salarié 3 (homme, 105 cm) : risque élevé (102 cm ou plus). Salariée 4 (femme, 92 cm) :

risque élevé (88 cm ou plus). Salarié 5 (homme, 97 cm) : risque accru (94 à 101 cm).

4. Chez l'enfant, la corpulence varie normalement avec l'âge et le sexe (rebond d'adiposité vers 6 ans) : un seuil fixe n'a pas de sens. On utilise les courbes de référence françaises de corpulence du carnet de santé (2018) et les seuils internationaux IOTF-25 (surpoids) et IOTF-30 (obésité).

Corrigé – Exercice 2.29

1. p = 61 / 320 = 0,1906, soit 19,06 %.
2. Marge = 1,96 × √(0,1906 × 0,8094 / 320) = 1,96 × √0,000482 = 1,96 × 0,02195 = 0,043, soit 4,3 points. Intervalle de confiance à 95 % : 19,06 − 4,3 = 14,8 % à 19,06 + 4,3 = 23,4 %.
3. Pour n = 80 : 1,96 × √(0,1906 × 0,8094 / 80) = 0,086, soit 8,6 points (intervalle de 10,5 % à 27,7 %). Pour p = 19 % et n = 1 280 : 1,96 × √(0,19 × 0,81 / 1 280) = 0,021, soit 2,1 points (16,9 % à 21,1 %).
4. Passer de 320 à 1 280 personnes (effectif multiplié par 4) divise la marge d'erreur par 2 (4,3 points à 2,1 points). La marge varie comme l'inverse de la racine carrée de l'effectif.
5. L'intervalle de confiance ne corrige que le hasard de l'échantillonnage. Il ne corrige pas les biais : les volontaires d'une journée de prévention ne sont pas représentatifs des adhérents (âge, sexe, intérêt pour la santé). La mutuelle peut annoncer « environ 19 % d'obésité parmi les 320 participants », pas « chez nos adhérents ».

Corrigé – Exercice 2.30

1. Quartier : moins de 18 ans 1 624 / 5 600 × 100 = 29,0 % ; 65 ans ou plus 840 / 5 600 × 100 = 15,0 % ; familles monoparentales 196 / 588 × 100 = 33,3 %. Commune : moins de 18 ans 6 150 / 31 000 × 100 = 19,8 % ; 65 ans ou plus 7 440 / 31 000 × 100 = 24,0 % ; familles monoparentales 722 / 4 250 × 100 = 17,0 %.
2. Surpoids des enfants de CE1 du quartier : 19 / 112 × 100 = 17,0 %, contre 11,2 % dans le département, soit 5,8 points de plus.
3. Pauvreté : écart absolu 36 − 13 = 23 points ; écart relatif 36 / 13 = 2,8.
4. Exemples : « Le quartier du Moulin est jeune : 29,0 % de ses 5 600 habitants ont moins de 18 ans, contre 19,8 % dans la commune (Insee, données fictives de l'exercice). » « Un tiers des familles avec enfants (33,3 %) sont monoparentales, deux fois plus que dans la commune (17,0 %). » « Le taux de pauvreté atteint 36 %, soit 2,8 fois celui de la commune (13 %) et plus du double de la moyenne française (14 à 15 %, Insee). » « 17,0 % des enfants de CE1 examinés en 2025-2026 sont en surpoids, contre 11,2 % dans le département (bilans de santé scolaire, n = 112). »
5. Public prioritaire : les familles avec enfants, en particulier les familles monoparentales. Déterminants à prendre en compte : économiques (pauvreté, budget alimentaire) et organisationnels (temps disponible des parents seuls), ainsi que l'environnement alimentaire du quartier.
6. Limites : le surpoids des enfants repose sur 112 enfants (marge d'erreur d'environ 7 points) ; les données sociales ne sont pas toutes de la même année ; le portrait ne dit rien des besoins ressentis par les familles, qu'il faudra recueillir par questionnaire ou entretiens.

Partie 6 – Transitions et fardeau des maladies chroniques

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire les quatre phases de la transition démographique et situer la France.
- Expliquer la transition épidémiologique (Omran, 1971) et la transition nutritionnelle (Popkin, 1993) ; définir le double fardeau de la malnutrition.
- Calculer des années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI) et un nombre de cas attribuables.
- Argumenter, avec des données datées, la priorité donnée à la nutrition dans les politiques de santé.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Transition démographique : phase 1 natalité et mortalité élevées ; phase 2 baisse de la mortalité ; phase 3 baisse de la natalité ; phase 4 natalité et mortalité basses, vieillissement.
- Transition épidémiologique (Omran, 1971) : les maladies infectieuses et les carences reculent, les maladies chroniques non transmissibles dominent (environ 74 % des décès dans le monde, OMS, 2023).
- Transition nutritionnelle (Popkin, 1993) : cinq stades, de la cueillette au changement de comportement ; hausse des produits animaux, sucres, graisses et aliments transformés, baisse de l'activité physique.
- AVCI = années de vie perdues (AVP) + années vécues avec incapacité (AVI). AVP = décès × années perdues par décès. AVI = cas × poids d'incapacité × durée.
- Global Burden of Disease 2017 (Lancet, 2019) : les risques alimentaires sont responsables d'environ 11 millions de décès et 255 millions d'AVCI dans le monde ; premier facteur : l'excès de sodium.
- Cancers en France : environ 433 000 nouveaux cas en 2023 (INCa) ; 41 % attribuables à des facteurs modifiables, dont alcool 8 %, alimentation 5,4 %, surpoids et obésité 5,4 %, activité physique insuffisante 0,9 % (CIRC, 2018, estimations pour 2015).

Exercice 2.31 – Légender la transition démographique (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez une séance d'information pour des bénévoles d'une association d'aide alimentaire qui accueille des familles venues de pays différents. Vous voulez expliquer pourquoi les problèmes de santé ne sont pas les mêmes selon les pays.

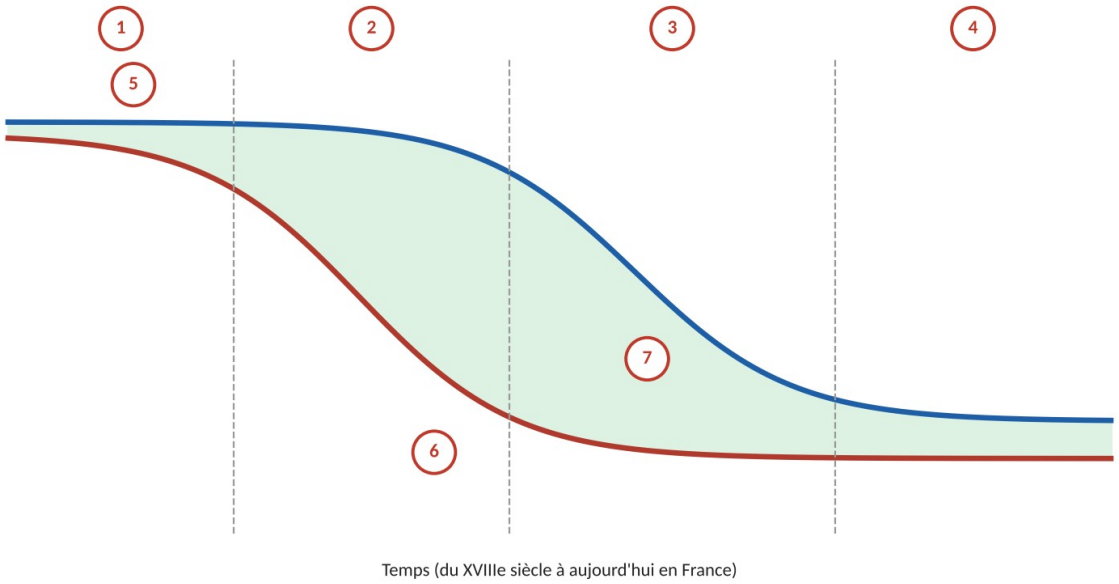


Figure 2.8 – Document 1 – Le modèle de la transition démographique (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)

2. Expliquez les causes de la baisse de la mortalité (phase 2) puis de la natalité (phase 3). (3 pts)

3. Situez la France et justifiez avec deux données récentes de l'Insee. (2 pts)

4. Indiquez la conséquence de la phase 4 pour la politique nutritionnelle. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.32 – Reconnaître les stades de la transition nutritionnelle (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un panneau d'exposition sur l'histoire de l'alimentation, vous devez associer des descriptions aux stades du modèle de Popkin.

Document 1 – Cinq descriptions

a) Les rations quotidiennes dépendent des récoltes ; les disettes sont fréquentes et les enfants ont des retards de croissance.

b) La population consomme beaucoup de plats préparés, de boissons sucrées et de viande ; l'obésité et le diabète progressent.

c) L'alimentation est variée, riche en fibres, issue de la chasse et de la cueillette ; les personnes sont actives et minces.

d) Les politiques publiques encouragent les légumineuses, les céréales complètes et l'activité physique ; la part des produits végétaux remonte.

e) La disponibilité en fruits, légumes et protéines animales augmente ; les carences reculent et la taille moyenne augmente.

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque description à un stade (1 à 5) du modèle de Popkin, dans l'ordre chronologique. (5 pts)
2. Définissez la transition nutritionnelle et citez son auteur et l'année. (2 pts)
3. Indiquez à quel stade correspondent les objectifs du PNNS. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.33 – Le double fardeau de la malnutrition (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de santé communautaire d'un territoire ultramarin (données fictives) a interrogé et examiné 400 ménages avec au moins un adulte et un enfant de moins de 5 ans.

Document 1 – Résultats (données fictives)

- Ménages avec au moins un adulte obèse : 148.
- Ménages avec au moins un enfant anémié (carence en fer) : 64.
- Ménages qui cumulent les deux : 31.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez le double fardeau de la malnutrition et expliquez le sens du mot malnutrition. (2 pts)

2. Calculez la part des ménages avec un adulte obèse, avec un enfant anémié et avec les deux. (3 pts)

3. Calculez le nombre de ménages qui cumuleraient les deux si les deux problèmes étaient indépendants ; comparez au nombre observé. (3 pts)

4. Expliquez comment une même alimentation peut provoquer à la fois l'obésité de l'adulte et une carence chez l'enfant. (2 pts)

5. Proposez une action qui répond aux deux problèmes à la fois. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.34 – Calculer des AVCI (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un ORS fictif vous demande d'estimer le fardeau de l'hypertension artérielle dans un territoire de 85 000 habitants, pour une année, afin de le comparer à celui d'autres problèmes de santé.

Document 1 – Données (fictives, une année)

- Décès attribués à l'hypertension et à ses complications : 20, survenus en moyenne 12 ans avant l'espérance de vie.
- Personnes hypertendues sans complication : 5 200, poids d'incapacité 0,03.
- Personnes avec une complication (insuffisance cardiaque, séquelles d'AVC) : 640, poids d'incapacité 0,15.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez une AVCI et donnez sa formule. (2 pts)
2. Calculez les années de vie perdues, les années vécues avec incapacité (pour chaque groupe) et le total des AVCI. (5 pts)
3. Calculez la part de l'incapacité dans le fardeau et le nombre d'AVCI pour 100 000 habitants. (2 pts)
4. Expliquez l'intérêt des AVCI par rapport à la seule mortalité et indiquez ce que cela change pour un programme nutritionnel. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.35 – Cancers attribuables à des facteurs nutritionnels (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un argumentaire pour la ligue contre le cancer de votre département, qui veut développer des ateliers sur l'alimentation et l'activité physique. On vous demande des ordres de grandeur nationaux.

Document 1 – Données

- Nouveaux cas de cancer en France en 2023 : environ 433 000 (INCa).
- Part des cancers attribuables à des facteurs modifiables (CIRC, 2018, estimations pour les cancers de 2015) : 41 % au total, dont tabac 19,8 %, alcool 8 %, alimentation 5,4 %, surpoids et obésité 5,4 %, activité physique insuffisante 0,9 %.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre approximatif de cancers attribuables à l'alcool, à l'alimentation, au surpoids et à l'obésité, et à l'activité physique insuffisante, en appliquant ces fractions aux cas de 2023. (4 pts)

2. Calculez la part et le nombre de cancers liés aux trois facteurs nutritionnels au sens strict (alimentation, surpoids et obésité, activité physique), puis avec l'alcool. (3 pts)

3. Expliquez pourquoi ces résultats sont des ordres de grandeur et pas des valeurs exactes. (2 pts)

4. Rédigez la phrase d'accroche de l'argumentaire, avec ses sources. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.36 – Convaincre des élus de la priorité nutritionnelle (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au service de santé publique d'une métropole. Lors de la préparation du budget, un élu déclare : « La nutrition, c'est du confort. Nos priorités sont les urgences et les hôpitaux. » Le directeur vous demande une note de 15 lignes pour la commission santé.

Document 1 – Données disponibles

- Maladies chroniques : environ 74 % des décès dans le monde (OMS, 2023).
- Risques alimentaires : environ 11 millions de décès et 255 millions d'AVCI dans le monde en 2017, davantage que le tabac ; premier facteur : l'excès de sodium (GBD 2017, Lancet, 2019).
- Maladies cardio-neurovasculaires : deuxième cause de décès en France (21,2 % des décès en 2024, Drees, Inserm-CépiDc, Santé publique France, juin 2026).
- Diabète : plus de 3,8 millions de personnes traitées en France en 2023, soit 5,6 % de la population (Santé publique France, 2024).
- Surpoids : 49 % des adultes, dont 17 % d'obésité (Esteban, mesures 2015) ; obésité déclarée de 24,7 % chez les adultes en difficulté économique contre 18,1 % pour l'ensemble (OFÉO, 2024).

À vous de jouer – Questions

1. Relevez dans le document 1 trois arguments qui montrent que la nutrition n'est pas du confort. (3 pts)

2. Expliquez le lien entre la nutrition et la pression sur les hôpitaux. (3 pts)

3. Ajoutez un argument d'équité à partir des données OFÉO ; calculez l'écart absolu et relatif. (3 pts)

4. Rédigez la note (15 lignes) avec une proposition concrète pour la métropole. (7 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 2.31

1. Légendes : 1 Phase 1 : natalité et mortalité élevées ; 2 Phase 2 : la mortalité baisse ; 3 Phase 3 : la natalité baisse ; 4 Phase 4 : natalité et mortalité basses, vieillissement ; 5 Taux de natalité ; 6 Taux de mortalité ; 7 Accroissement naturel fort.
2. Phase 2 : la mortalité baisse grâce à une alimentation plus régulière (fin des famines), à l'hygiène, à l'eau potable, puis à la vaccination et à la médecine. Phase 3 : la natalité baisse avec la scolarisation, l'urbanisation, le travail des femmes, la contraception et la baisse de la mortalité infantile (il n'est plus nécessaire d'avoir beaucoup d'enfants).
3. La France est en phase 4. En 2025, l'indicateur conjoncturel de fécondité est de 1,56 enfant par femme et le solde naturel est négatif pour la première fois depuis 1945 (environ − 6 000) ; 22,2 % des habitants ont 65 ans ou plus au 1er janvier 2026 (Insee, 2026).
4. Le vieillissement augmente le nombre de personnes à risque de dénutrition et de maladies chroniques : la politique nutritionnelle doit prévenir la dénutrition et la perte d'autonomie, en plus des maladies chroniques.

Corrigé – Exercice 2.32

1. Ordre chronologique : c) stade 1, cueillette ; a) stade 2, famines ; e) stade 3, recul des famines ; b) stade 4, maladies chroniques liées à l'alimentation ; d) stade 5, changement de comportement.
2. La transition nutritionnelle (Barry Popkin, 1993) est l'évolution des régimes alimentaires qui accompagne le développement économique et l'urbanisation : moins de céréales peu raffinées, de légumineuses et de légumes ; plus de produits animaux, de sucres ajoutés, de graisses et d'aliments transformés ; moins d'activité physique. Elle s'accompagne d'une hausse du surpoids, de l'obésité et des maladies chroniques.
3. Le PNNS vise le stade 5, celui du changement de comportement : plus de végétal, de fibres et d'activité physique, grâce aux politiques publiques.

Corrigé – Exercice 2.33

1. Le double fardeau de la malnutrition est la coexistence, dans une même population, un même foyer ou chez une même personne, de la dénutrition ou des carences et du surpoids ou de l'obésité. La malnutrition désigne tous les déséquilibres nutritionnels, par défaut ou par excès, et pas seulement la dénutrition.
2. Adulte obèse : 148 / 400 × 100 = 37,0 %. Enfant anémié : 64 / 400 × 100 = 16,0 %. Les deux : 31 / 400 × 100 = 7,75 %.
3. Si les deux problèmes étaient indépendants : 400 × 0,37 × 0,16 = 148 × 64 / 400 = 23,7 ménages. On en observe 31, soit plus que prévu : les deux problèmes ont des causes communes dans ces ménages.
4. Une alimentation dense en énergie mais pauvre en micronutriments (produits raffinés, boissons sucrées, peu de légumes, de légumineuses et de viande ou de poisson) apporte trop de calories à l'adulte et trop peu de fer à l'enfant. La pauvreté et l'offre alimentaire en sont souvent la cause commune.
5. Exemple : des ateliers cuisine pour les familles autour des légumineuses et des produits locaux riches en fer, associés à une source de vitamine C, avec des recettes peu coûteuses ; en lien avec la PMI pour le dépistage de l'anémie.

Corrigé – Exercice 2.34

1. Une AVCI (année de vie corrigée de l'incapacité, DALY en anglais) représente une année de vie en bonne santé perdue. AVCI = années de vie perdues par décès prématuré (AVP) + années vécues avec une incapacité (AVI).

2. AVP = 20 × 12 = 240. AVI sans complication = 5 200 × 0,03 × 1 = 156. AVI avec complication = 640 × 0,15 × 1 = 96. Total AVCI = 240 + 156 + 96 = 492.

3. Part de l'incapacité = (156 + 96) / 492 × 100 = 51,2 %. AVCI pour 100 000 habitants = 492 / 85 000 × 100 000 = 578,8.

4. Plus de la moitié du fardeau vient de l'incapacité et non des décès : un indicateur de mortalité seul sous-estimerait le problème. Pour un programme nutritionnel, cela justifie d'agir sur la prévention des complications (réduction du sel, alimentation de type DASH, activité physique, perte de poids) chez les personnes déjà hypertendues, et pas seulement sur la prévention des décès.

Corrigé – Exercice 2.35

1. Nombre de cas = 433 000 × fraction. Alcool : 433 000 × 0,08 = 34 640. Alimentation : 433 000 × 0,054 = 23 382. Surpoids et obésité : 433 000 × 0,054 = 23 382. Activité physique insuffisante : 433 000 × 0,009 = 3 897.

2. Facteurs nutritionnels au sens strict : 5,4 + 5,4 + 0,9 = 11,7 %, soit 433 000 × 0,117 = 50 661 cas environ. Avec l'alcool : 11,7 + 8 = 19,7 %, soit 433 000 × 0,197 = 85 301 cas environ, autant que le tabac (19,8 %).

3. Les fractions ont été estimées pour les cancers de 2015 ; on les applique aux cas de 2023 en supposant qu'elles n'ont pas changé. Ce sont des estimations fondées sur des risques relatifs issus d'études et sur des prévalences d'exposition : on arrondit et on parle d'ordre de grandeur (« environ 50 000 cas par an »).

4. Exemple : « En France, environ un cancer sur cinq (19,7 %) est lié à l'alcool, à l'alimentation, au surpoids ou au manque d'activité physique, soit de l'ordre de 85 000 nouveaux cas par an (CIRC, 2018 ; INCa, 2023) : agir sur la nutrition, c'est prévenir autant de cancers qu'en luttant contre le tabac. »

Corrigé – Exercice 2.36

1. Arguments : les maladies chroniques causent environ 74 % des décès dans le monde (OMS, 2023) ; les risques alimentaires tuent davantage que le tabac (11 millions de décès en 2017, GBD) ; les maladies cardio-neurovasculaires, liées au sel, aux graisses et au surpoids, sont la deuxième cause de décès en France (21,2 % en 2024).

2. Les maladies liées à la nutrition (diabète, maladies cardio-vasculaires, cancers, obésité) sont des maladies chroniques qui entraînent des hospitalisations répétées, des passages aux urgences (AVC, infarctus, plaies du pied diabétique) et des traitements longs. La dénutrition des personnes âgées allonge les séjours et augmente les complications. Prévenir ces maladies réduit la demande hospitalière à moyen terme.

3. Écart absolu : 24,7 − 18,1 = 6,6 points. Écart relatif : 24,7 / 18,1 = 1,36. L'obésité déclarée est 1,36 fois plus fréquente chez les adultes en difficulté économique (OFÉO, 2024) : la nutrition est aussi une question de justice sociale.

4. Exemple de note : « La nutrition n'est pas un confort mais un déterminant majeur de la santé. Les maladies chroniques causent environ 74 % des décès dans le monde (OMS, 2023), et les risques alimentaires sont responsables de 11 millions de décès par an, plus que le tabac (GBD 2017, Lancet, 2019). En France, les maladies cardio-neurovasculaires représentent 21,2 % des décès (Drees, Inserm-CépiDc, Santé publique France, juin 2026) et plus de 3,8 millions de personnes sont traitées pour un diabète (Santé publique France, données 2023). Ces maladies remplissent les urgences et les services hospitaliers : les prévenir, c'est réduire à terme la pression sur l'hôpital. Elles frappent davantage les plus modestes : l'obésité déclarée atteint 24,7 % chez les adultes en difficulté économique contre 18,1 % pour l'ensemble (OFÉO, 2024). Nous proposons que la métropole s'engage sur trois mesures : réduire le sel dans la restauration scolaire et les EHPAD municipaux, financer des ateliers cuisine dans les quartiers prioritaires, et intégrer la santé dans le projet alimentaire territorial. Le coût est faible au regard des dépenses évitées. »

Partie 7 – Mesurer une association, raisonner sur la causalité

Objectifs – Objectifs de la partie

- Construire un tableau de contingence 2 × 2 à partir de données d'enquête.
- Calculer et interpréter un risque relatif, une différence de risques, un odds ratio et des fractions attribuables.
- Reconnaître un facteur de confusion et le contrôler par la stratification.
- Distinguer les types d'études (transversale, cas-témoins, cohorte, essai) et discuter la causalité.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- R1 = a / (a + b) (exposés) ; R0 = c / (c + d) (non-exposés) ; RR = R1 / R0 ; DR = R1 − R0 ; OR = (a × d) / (b × c).
- RR = 1 : pas d'association ; RR > 1 : facteur de risque ; RR < 1 : facteur protecteur. L'OR est proche du RR quand la maladie est rare.
- Fraction attribuable chez les exposés = (RR − 1) / RR. Fraction attribuable dans la population = pe × (RR − 1) / [1 + pe × (RR − 1)], où pe est la part d'exposés.
- Facteur de confusion : lié à la fois à l'exposition et à l'effet ; il peut créer ou masquer une association. On le contrôle par la stratification ou l'ajustement.
- Arguments de causalité (Bradford Hill, 1965) : force de l'association, constance entre études, temporalité (la cause précède l'effet), relation dose-effet, plausibilité biologique, cohérence, preuve expérimentale.

Exercice 2.37 – Légender le tableau de contingence (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Avant de traiter les données d'une enquête de stage, vous révisez la construction d'un tableau de contingence et les formules associées.

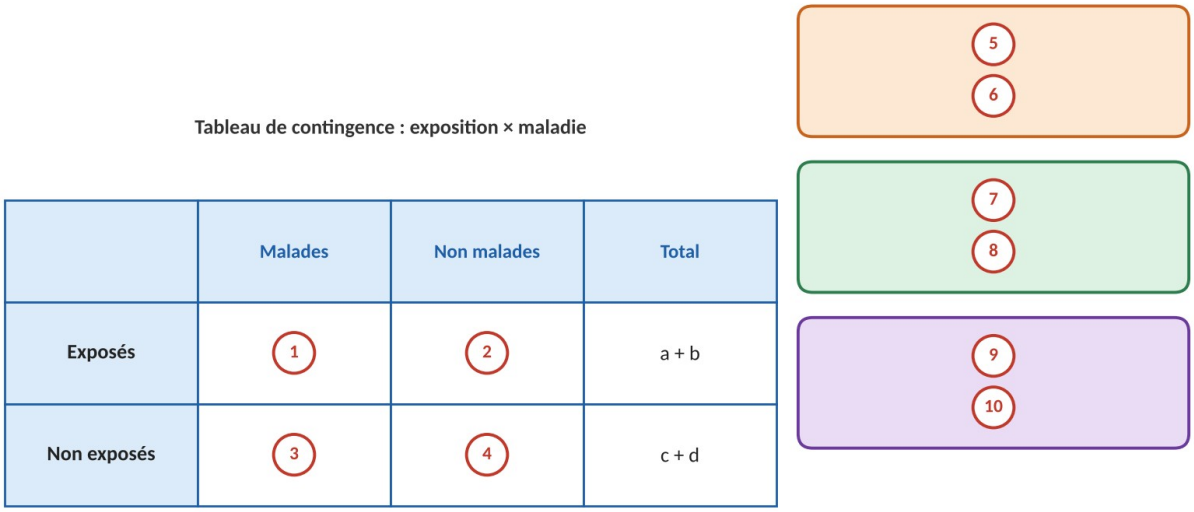


Figure 2.9 – Document 1 – Tableau de contingence et mesures d'association (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (5 pts)

2. Indiquez ce que l'on place en lignes et en colonnes, et ce que représentent a + b et c + d. (1,5 pt)

3. Indiquez la mesure à utiliser dans une étude cas-témoins et expliquez pourquoi. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.38 – Petit-déjeuner et surpoids au collège (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'infirmière d'un collège (données fictives) a croisé, pour 600 élèves de 4e et de 3e, le fait de ne pas prendre de petit-déjeuner au moins 4 jours sur 5 et le surpoids mesuré au bilan de santé.

Document 1 – Résultats de l'enquête (données fictives, 2026)

- 140 élèves ne prennent pas de petit-déjeuner au moins 4 jours sur 5 ; 38 d'entre eux sont en surpoids.
- 460 élèves prennent un petit-déjeuner ; 69 d'entre eux sont en surpoids.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez le tableau de contingence. (2 pts)
2. Calculez R1, R0, le risque relatif et la différence de risques. (4 pts)
3. Calculez l'odds ratio et expliquez pourquoi il est supérieur au risque relatif. (2 pts)
4. Calculez la fraction attribuable chez les exposés et dans la population, puis le nombre de cas concernés. (4 pts)
5. Indiquez pourquoi ce résultat ne prouve pas que sauter le petit-déjeuner fait grossir. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.39 – Sel et hypertension : fractions attribuables (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service de santé au travail (données fictives) suit 2 400 salariés hypertendus. Les études disponibles donnent, pour une consommation de sel supérieure à 8 g par jour, un risque relatif d'hypertension de 1,4 ; dans cette population, 62 % des salariés dépassent ce seuil.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la fraction attribuable chez les exposés ; interprétez. (2 pts)
2. Calculez la fraction attribuable dans la population ; interprétez. (3 pts)
3. Calculez le nombre d'hypertensions, parmi les 2 400, qui seraient évitées si personne ne dépassait 8 g de sel par jour. (2 pts)
4. Indiquez la condition indispensable pour que ce calcul ait un sens et une action possible du service. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.40 – Démasquer un facteur de confusion (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – analyse · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association qui accompagne des personnes en hébergement temporaire (données fictives) a interrogé 600 adultes. Elle conclut : « Ne pas avoir de cuisine fait sauter des repas : il faut équiper tous les logements. » Vous vérifiez cette conclusion.

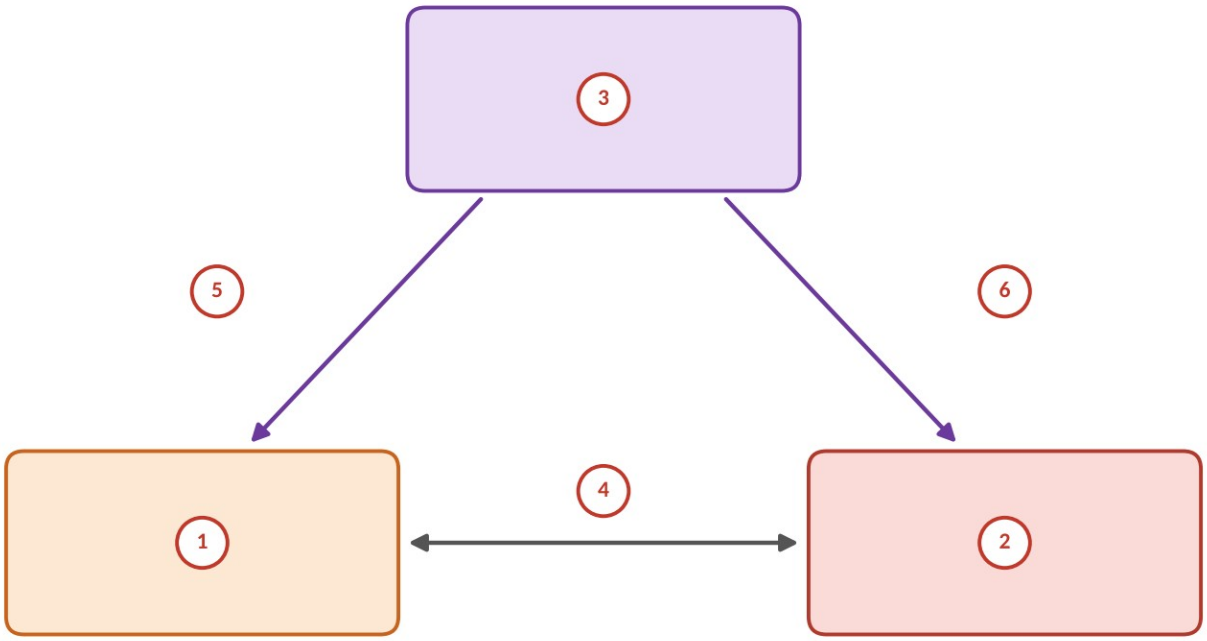


Figure 2.10 – Document 1 – Le facteur de confusion (schéma à légender)

Document 2 – Sauter au moins un repas par jour selon l'équipement et le revenu (données fictives)

Revenu	Équipement	Effectif	Sautent au moins un repas par jour
Faible	Sans cuisine	150	75
Faible	Avec cuisine	100	42
Non faible	Sans cuisine	30	9
Non faible	Avec cuisine	320	80
Ensemble	Sans cuisine	180	84
Ensemble	Avec cuisine	420	122

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Calculez le risque relatif brut (ensemble). (2 pts)

3. Calculez le risque relatif dans chaque strate de revenu. (3 pts)

4. Calculez la part de personnes sans cuisine dans chaque strate de revenu. (1 pt)

5. Concluez : le revenu est-il un facteur de confusion ? Que devient l'effet propre de la cuisine ? (3 pts)

6. Reformulez la conclusion de l'association. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.41 – Types d'études et niveau de preuve (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour la partie « données probantes » de votre dossier, vous classez quatre études sur les boissons sucrées.

Document 1 – Quatre études (descriptions simplifiées)

a) 3 000 adolescents interrogés en une fois sur leur consommation de sodas et pesés le même jour.

b) 200 enfants ayant des caries précoces et 400 enfants sans caries, du même âge, interrogés sur leur consommation passée de jus et de sodas.

c) 15 000 adultes sans diabète suivis pendant 10 ans ; on compare l'apparition du diabète selon la consommation de boissons sucrées déclarée au départ.

d) 640 enfants tirés au sort : la moitié reçoit chaque jour une boisson sans sucre, l'autre moitié une boisson sucrée, pendant 18 mois ; on compare la prise de poids.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le type de chaque étude et la mesure d'association adaptée. (4 pts)
2. Classez les études selon leur niveau de preuve ; justifiez. (2 pts)
3. Citez trois arguments de Bradford Hill et illustrez chacun avec ces études. (3 pts)
4. Indiquez pourquoi l'étude d n'est pas possible pour tous les sujets de nutrition. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.42 – Lecture critique d'un article de presse (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un participant d'un atelier vous montre un article et vous demande s'il doit manger du chocolat tous les jours pour maigrir. Vous devez lui répondre simplement, puis rédiger une analyse pour votre tutrice.

Document 1 – Extrait de l'article (fictif)

« Le chocolat fait maigrir ! Une enquête menée auprès de 1 000 internautes volontaires montre que ceux qui mangent du chocolat au moins 5 fois par semaine ont un IMC moyen plus bas (24,1 contre 25,3) que les autres. Les chercheurs, financés par un fabricant de confiserie, recommandent d'en manger chaque jour. »

À vous de jouer – Questions

1. Identifiez le type d'étude et ce qu'elle peut montrer. (2 pts)
2. Relevez cinq limites de cette étude ou de l'article (recrutement, mesure, confusion, causalité inverse, financement). (5 pts)
3. Proposez deux facteurs de confusion possibles. (2 pts)
4. Rédigez la réponse au participant en trois phrases, sans le juger. (3 pts)
5. Indiquez le type d'étude qui permettrait de répondre vraiment à la question. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 2.37

1. Légendes : 1 a ; 2 b ; 3 c ; 4 d ; 5 Risque relatif ; 6 RR = [a / (a + b)] / [c / (c + d)] ; 7 Odds ratio ; 8 OR = (a × d) / (b × c) ; 9 Fraction attribuable chez les exposés ; 10 FA = (RR − 1) / RR.
2. En lignes : l'exposition (exposés, non-exposés) ; en colonnes : la maladie (malades, non malades). a + b est le nombre total d'exposés, c + d le nombre total de non-exposés.
3. Dans une étude cas-témoins, on choisit des malades (cas) et des non-malades (témoins) : on fixe le nombre de malades, on ne peut donc pas calculer un risque de maladie. On calcule l'odds ratio, qui est proche du risque relatif quand la maladie est rare.

Corrigé – Exercice 2.38

1. Tableau : exposés (sans petit-déjeuner) : a = 38 en surpoids, b = 140 − 38 = 102 sans surpoids, total 140. Non-exposés : c = 69 en surpoids, d = 460 − 69 = 391 sans surpoids, total 460. Total : 107 en surpoids, 493 sans surpoids, 600 élèves.
2. R1 = 38 / 140 = 0,271 (27,1 %). R0 = 69 / 460 = 0,150 (15,0 %). RR = 0,271 / 0,150 = 1,81. DR = 27,1 − 15,0 = 12,1 points. Le surpoids est 1,81 fois plus fréquent chez les élèves qui ne prennent pas de petit-déjeuner.
3. OR = (38 × 391) / (102 × 69) = 14 858 / 7 038 = 2,11. Il est supérieur au RR parce que le surpoids n'est pas rare ici (plus de 15 % des élèves) : l'OR s'éloigne du RR quand la maladie est fréquente.
4. Fraction attribuable chez les exposés = (1,81 − 1) / 1,81 = 0,447, soit 44,7 %. Part d'exposés pe = 140 / 600 = 0,233. Fraction attribuable dans la population = 0,233 × 0,81 / (1 + 0,233 × 0,81) = 0,159, soit 15,9 %. Nombre de cas : 107 × 0,159 = 17 élèves en surpoids environ, si la relation était causale.
5. C'est une enquête transversale : on ne sait pas qui vient en premier (des élèves en surpoids peuvent sauter le petit-déjeuner pour maigrir : causalité inverse). D'autres facteurs peuvent expliquer l'association : milieu social, sommeil, écrans (confusion).

Corrigé – Exercice 2.39

1. FAE = (1,4 − 1) / 1,4 = 0,286, soit 28,6 % : parmi les salariés hypertendus qui consomment plus de 8 g de sel par jour, environ 29 % de leurs hypertensions seraient dues à ce sel.
2. FAP = 0,62 × 0,4 / (1 + 0,62 × 0,4) = 0,248 / 1,248 = 0,199, soit 19,9 % : environ une hypertension sur cinq de toute la population suivie est attribuable à la consommation élevée de sel.
3. 2 400 × 0,199 = 477 hypertensions environ.
4. La relation doit être causale (c'est le cas pour le sel, d'après de nombreuses études et des essais) et le risque relatif doit venir de populations comparables. Action : réduire le sel dans le restaurant d'entreprise (pain, plats, salière), afficher la teneur en sel, proposer des ateliers « cuisiner sans trop saler ».

Corrigé – Exercice 2.40

1. Légendes : 1 Exposition : ne pas avoir de cuisine ; 2 Effet : sauter des repas ; 3 Facteur de confusion : faible revenu ; 4 Association observée ; 5 lié à l'exposition ; 6 lié à l'effet.
2. RR brut : R1 = 84 / 180 = 46,7 % ; R0 = 122 / 420 = 29,0 % ; RR = 0,467 / 0,290 = 1,61.
3. Revenu faible : R1 = 75 / 150 = 50,0 % ; R0 = 42 / 100 = 42,0 % ; RR = 1,19. Revenu non faible : R1 = 9 / 30 = 30,0 % ; R0 = 80 / 320 = 25,0 % ; RR = 1,20.
4. Part de personnes sans cuisine : revenu faible 150 / 250 × 100 = 60,0 % ; revenu non faible 30 / 350 × 100 = 8,6 %.
5. Oui : le faible revenu est lié à l'absence de cuisine (60,0 % contre 8,6 %) et au fait de sauter des repas (dans chaque groupe d'équipement, les personnes à faible revenu sautent plus souvent un repas). Une fois le revenu pris en compte, le risque relatif passe de 1,61 à environ 1,2 : l'effet propre de l'absence de

cuisine existe, mais il est beaucoup plus faible que ce que montrait le chiffre brut.

6. « Ne pas avoir de cuisine est associé à un risque un peu plus élevé de sauter des repas (environ 1,2 fois, à revenu égal), mais l'essentiel de l'écart observé s'explique par le faible revenu. Équiper les logements est utile, mais il faut d'abord agir sur l'accès financier à l'alimentation (aide alimentaire, épicerie solidaire, repas à tarif social). »

Corrigé – Exercice 2.41

1. a) Enquête transversale : prévalences et association (risque relatif de prévalence ou OR). b) Étude cas-témoins : odds ratio. c) Étude de cohorte : risque relatif d'incidence. d) Essai contrôlé randomisé : différence de prise de poids entre les deux groupes.
2. Du plus faible au plus fort : transversale (a), cas-témoins (b), cohorte (c), essai randomisé (d). L'essai randomisé répartit les facteurs de confusion au hasard entre les groupes et montre l'effet d'une intervention ; la cohorte établit que l'exposition précède la maladie ; les études transversales et cas-témoins sont plus exposées aux biais (mémoire, causalité inverse).
3. Temporalité : dans la cohorte c, la consommation est mesurée avant l'apparition du diabète. Preuve expérimentale : l'essai d montre qu'enlever le sucre des boissons réduit la prise de poids. Constance : les quatre études, de types différents, vont dans le même sens. On peut aussi citer la plausibilité biologique (sucres liquides peu rassasiants) ou la relation dose-effet (plus de boissons, plus de risque).
4. On ne peut pas, pour des raisons éthiques et pratiques, tirer au sort des personnes pour les exposer pendant des années à un facteur supposé nocif (alcool, aliments ultra-transformés) ni attendre l'apparition d'un cancer.

Corrigé – Exercice 2.42

1. Enquête transversale par questionnaire en ligne : elle peut montrer une association entre consommation de chocolat et IMC, pas une cause.
2. Limites : volontaires internautes, non représentatifs ; poids et taille probablement déclarés (sous-estimation) ; facteurs de confusion non pris en compte ; causalité inverse possible (les personnes qui surveillent leur poids ou qui en ont pris peuvent éviter le chocolat) ; écart d'IMC faible (1,2 point) sans marge d'erreur ; financement par un fabricant (conflit d'intérêts) ; recommandation qui dépasse ce que l'étude peut montrer.
3. Facteurs de confusion : activité physique (les sportifs mangent peut-être plus de chocolat), âge (les plus jeunes ont un IMC plus bas et mangent plus de chocolat), niveau socio-économique.
4. Exemple : « Cette étude montre seulement que les personnes qui mangent du chocolat ont en moyenne un IMC un peu plus bas, pas que le chocolat fait maigrir. Les personnes interrogées n'ont pas été pesées et d'autres différences peuvent expliquer le résultat. Vous pouvez continuer à manger du chocolat pour le plaisir, en quantité raisonnable, mais pas dans le but de perdre du poids. »
5. Un essai contrôlé randomisé : tirer au sort des personnes qui ajoutent du chocolat à leur alimentation et d'autres qui ne le font pas, et comparer l'évolution de leur poids mesuré, ou au moins une cohorte prospective avec mesures et ajustement sur les facteurs de confusion.

Partie 8 – Représenter des données, coût de l'alimentation, agir sur les déterminants

Objectifs – Objectifs de la partie

- Choisir le graphique adapté à des données et commenter un tableau ou un graphique en cinq phrases.
- Calculer le coût d'une portion et le coût de 20 g de protéines à partir de prix et de la table Ciqual 2025.
- Associer à chaque niveau du modèle de Dahlgren et Whitehead des leviers d'action ; conduire une évaluation d'impact sur la santé simplifiée.
- Calculer des indicateurs de périnatalité.
- Traiter un cas complet au format de l'épreuve E5.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Barres : comparer des catégories ; courbe : évolution dans le temps ; secteurs : répartition d'un tout ; pyramide : structure par âge et sexe ; carte : écarts entre territoires ; nuage de points : relation entre deux variables.
- Commenter en 5 phrases : présenter (quoi, qui, où, quand, source) ; tendance générale ; valeurs extrêmes avec unités ; un écart calculé ; interprétation et limites.
- Coût d'une portion = quantité (kg) × prix au kg. Coût de 20 g de protéines = coût de la portion × 20 / protéines de la portion.
- Santé dans toutes les politiques (déclaration d'Helsinki, OMS, 2013). Évaluation d'impact sur la santé (EIS) : estimer avant une décision ses effets sur la santé et sur les inégalités.
- Mortalité néonatale = décès avant 28 jours / naissances vivantes × 1 000. Prématurité : naissance avant 37 semaines d'aménorrhée. Petit poids de naissance : moins de 2 500 g.

Exercice 2.43 – Choisir le bon graphique (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez les diapositives de la soutenance de votre projet. Vous avez six séries de données et vous devez choisir, pour chacune, une représentation adaptée.

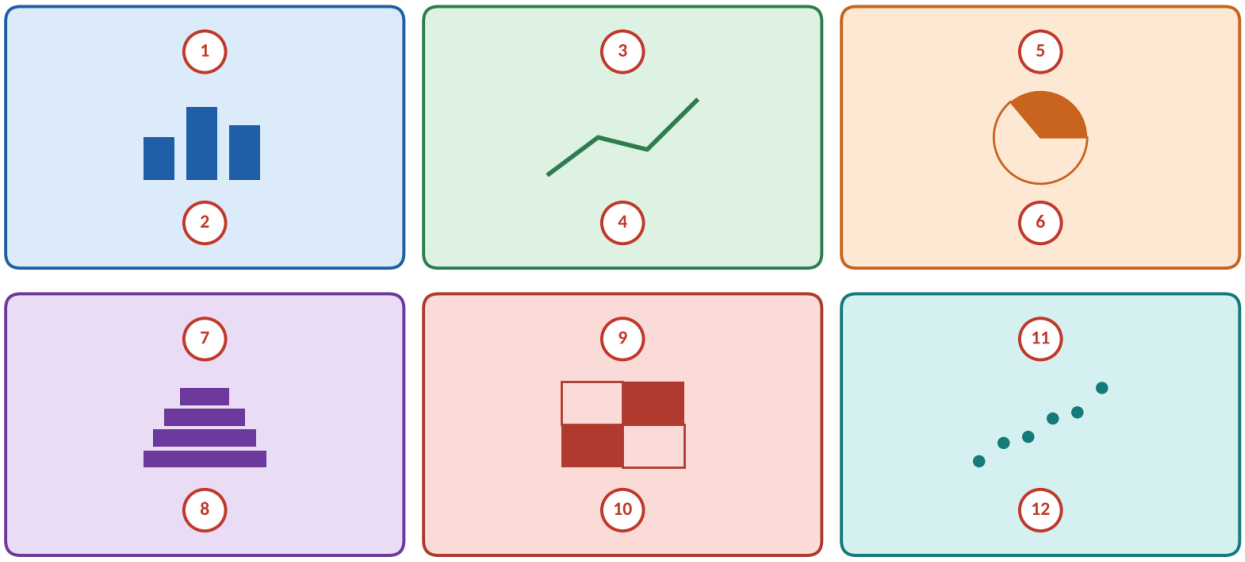


Figure 2.11 – Document 1 – Quel graphique pour quel message ? (schéma à légender)

Document 2 – Les six séries de données

a) Évolution du nombre de familles inscrites à l'épicerie solidaire de 2020 à 2026.

b) Répartition des 48 participants aux ateliers selon leur situation (en emploi, sans emploi, retraités, étudiants).

c) Part d'enfants en surpoids dans les 5 écoles de la commune.

d) Taux standardisé de mortalité prématurée dans les 14 communautés de communes du département.

e) Population du quartier par groupe d'âge de 10 ans et par sexe.

f) Pour 30 familles, revenu par unité de consommation et nombre de portions de fruits et légumes par jour.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (3 pts)
2. Associez à chaque série du document 2 le graphique le plus adapté ; justifiez. (6 pts)
3. Citez deux pièges graphiques à éviter. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.44 – Commenter des données en cinq phrases (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – rédaction · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une enquête régionale (données fictives, 2025) a mesuré la consommation quotidienne de boissons sucrées chez 2 500 adolescents de 11 à 15 ans, selon le niveau d'aisance de la famille, réparti en cinq groupes de taille égale (quintiles).

Document 1 – Adolescents buvant au moins une boisson sucrée par jour (données fictives, 2025)

Quintile d'aisance familiale	Q1 (les moins aisés)	Q2	Q3	Q4	Q5 (les plus aisés)
Part des adolescents (%)	38	33	29	24	19

À vous de jouer – Questions

1. Indiquez le graphique adapté et ses axes. (2 pts)

2. Rédigez un commentaire en cinq phrases, avec un écart absolu et un écart relatif. (6 pts)

3. Indiquez une limite de ces données. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.45 – Le coût des protéines (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un atelier « protéines à petit prix » pour les bénéficiaires d'une épicerie solidaire. Vous avez relevé des prix (fictifs) dans un supermarché de quartier et cherché les teneurs en protéines dans la table Ciqual 2025.

Document 1 – Prix relevés et teneurs en protéines

Aliment (code Ciqual 2025)	Portion	Prix	Protéines (g pour 100 g, Ciqual 2025)
Lentilles corail sèches (20535)	70 g	3,20 € le kg	27,7
Filet de poulet sans peau, cru (36017)	120 g	11,90 € le kg	23,4
Sardines à l'huile, égouttées (26034)	1 boîte, 95 g égouttés	1,35 € la boîte	23,3
Œufs crus (22000)	2 œufs, 100 g sans coquille	0,30 € l'œuf	12,8
Tofu nature (20904)	125 g	9,95 € le kg	13,4

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût de chaque portion. (2,5 pts)

2. Calculez la quantité de protéines apportée par chaque portion. (2,5 pts)

3. Calculez le coût de 20 g de protéines pour chaque aliment et classez-les du moins cher au plus cher. (3 pts)

4. Indiquez deux points de vigilance nutritionnelle sur les légumineuses et une astuce pratique pour l'atelier. (2 pts)

5. Expliquez pourquoi on compare ici le coût de 20 g de protéines et non le prix au kilo. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.46 – Leviers d'action et évaluation d'impact sur la santé (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une ville (fictive) étudie un projet d'aménagement : un restaurant rapide avec drive serait installé à 250 m d'un collège de 620 élèves, à la place d'un terrain vague que des associations voulaient transformer en jardin partagé. Le service santé vous demande une évaluation d'impact sur la santé simplifiée.

Document 1 – Éléments du dossier

- Le collège n'autorise pas la sortie des demi-pensionnaires le midi ; les externes (34 % des élèves) peuvent sortir.
- Le quartier compte déjà 7 points de restauration rapide et aucun primeur.
- Le projet créerait 18 emplois, dont des emplois étudiants.
- Le jardin partagé prévoyait des ateliers avec le collège et le centre social.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez l'évaluation d'impact sur la santé et la « santé dans toutes les politiques ». (2 pts)

2. Présentez les effets positifs et négatifs possibles du projet sur la santé, en citant les groupes les plus concernés. (4 pts)

3. Classez quatre leviers d'action selon les niveaux du modèle de Dahlgren et Whitehead. (4 pts)

4. Formulez trois recommandations à la ville. (3 pts)

5. Indiquez le rôle du diététicien dans cette démarche. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.47 – Indicateurs de périnatalité (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de protection maternelle et infantile (PMI) d'un département (données fictives) prépare un programme « 1000 premiers jours ». Vous calculez les indicateurs de l'année 2025.

Document 1 – Données de l'année 2025 (fictives)

- Naissances vivantes : 9 820.
- Décès avant 1 an : 41, dont 27 avant 28 jours.
- Naissances prématurées (avant 37 semaines d'aménorrhée) : 742.
- Naissances vivantes de moins de 2 500 g : 708.
- Enfants allaités à la sortie de la maternité : 6 540.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de mortalité infantile et le taux de mortalité néonatale. (2 pts)
2. Calculez la part de la mortalité infantile qui survient avant 28 jours. (1 pt)
3. Calculez la part de naissances prématurées, de petits poids de naissance et d'enfants allaités à la sortie de la maternité. (3 pts)
4. Proposez deux actions nutritionnelles du programme en lien avec ces indicateurs. (2 pts)
5. Indiquez pourquoi le taux de mortalité infantile d'un département doit être lu avec prudence. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.48 – Cas complet : le collège des Peupliers (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve E5 · durée conseillée : 2 heures*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage auprès du service de promotion de la santé d'un conseil départemental (structure fictive). Le collège des Peupliers, classé en réseau d'éducation prioritaire renforcé (REP+), accueille 540 élèves. Le principal et l'infirmière s'inquiètent de la fatigue des élèves le matin et de la faible fréquentation de la cantine. Le département met 4 000 € à disposition pour une action pendant l'année scolaire. Votre tutrice vous confie le diagnostic et la proposition d'action.

Document 1 – Fréquentation de la demi-pension (données fictives, septembre 2026)

Élèves	Effectif	Inscrits à la demi-pension
Boursiers	312	128
Non boursiers	228	171
Ensemble	540	299

Tarif du repas : 3,40 €. Un tarif réduit de 1,20 € existe pour les familles boursières, mais beaucoup ne le demandent pas.

Document 2 – Questionnaire auprès de 210 élèves de 5e et de 4e (données fictives, octobre 2026)

	Fatigue fréquente en fin de matinée	Pas de fatigue fréquente	Total
Pas de petit-déjeuner au moins 3 jours sur 5	34	29	63
Petit-déjeuner au moins 3 jours sur 5	41	106	147
Total	75	135	210

Document 3 – Bilan de santé de l'infirmière en 6e (données fictives, 2025-2026)

128 élèves pesés et mesurés : 31 en surpoids (obésité comprise), dont 9 en situation d'obésité, selon les seuils IOTF.

Document 4 – Extraits d'entretiens

- Une mère : « Le matin je pars à 6 h pour le ménage dans les bureaux, les enfants se préparent seuls. »
- Un élève : « À la cantine on ne connaît pas ce qu'il y a, et mes copains rentrent chez eux. »
- Le gestionnaire : « Les dossiers de tarif réduit sont en français seulement, et il faut les déposer au secrétariat de 9 h à 11 h. »
- L'infirmière : « Les élèves qui ne mangent pas le midi achètent souvent des chips et des sodas à l'épicerie en face. »

À vous de jouer – Questions

Partie A – Diagnostic (16 points)

1. Calculez le taux d'inscription à la demi-pension des boursiers, des non-boursiers et de l'ensemble ; calculez l'écart absolu et l'écart relatif. (4 pts)
2. Calculez la part d'élèves qui ne prennent pas de petit-déjeuner au moins 3 jours sur 5. (1 pt)

3. Calculez le risque de fatigue chez les élèves sans petit-déjeuner et chez les autres, le risque relatif et la différence de risques ; interprétez avec prudence. (4 pts)

4. Calculez la prévalence du surpoids et de l'obésité en 6e et la marge d'erreur de la prévalence du surpoids ; comparez aux données Esteban 2015. (3 pts)

5. Classez les éléments du document 4 selon les niveaux du modèle de Dahlgren et Whitehead. (4 pts)

Partie B – Proposition d'action (18 points)

6. Formulez le problème prioritaire en une phrase et justifiez le choix du public. (3 pts)

7. Rédigez un objectif général et trois objectifs spécifiques SMART. (6 pts)

8. Proposez trois actions, dont une au moins sur l'environnement, en appliquant l'universalisme proportionné. (5 pts)

9. Présentez un budget prévisionnel de 4 000 € au plus. (4 pts)

Partie C – Évaluation et éthique (6 points)

10. Proposez quatre indicateurs d'évaluation (processus et résultat), dont un qui mesure la réduction des inégalités. (4 pts)

11. Indiquez deux précautions éthiques. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 2.43

1. Légendes : 1 Diagramme en barres ; 2 comparer des catégories ou des territoires ; 3 Courbe ; 4 montrer une évolution dans le temps ; 5 Diagramme circulaire ; 6 montrer la répartition d'un tout (100 %) ; 7 Pyramide des âges ; 8 décrire la structure d'une population ; 9 Carte ; 10 montrer des écarts entre territoires ; 11 Nuage de points ; 12 montrer la relation entre deux variables.
2. a) Courbe : une évolution dans le temps (années en abscisse). b) Diagramme circulaire (ou barres empilées à 100 %) : répartition d'un tout en quatre catégories. c) Diagramme en barres : comparaison de cinq écoles. d) Carte en classes de couleur : écarts entre 14 territoires. e) Pyramide des âges : structure par âge et par sexe. f) Nuage de points : relation entre deux variables mesurées chez chaque famille.
3. Pièges : axe des ordonnées qui ne commence pas à zéro pour des barres ; secteurs en trois dimensions ; absence de source, de date ou d'effectif ; trop de couleurs ; mélange de taux bruts et standardisés.

Corrigé – Exercice 2.44

1. Diagramme en barres verticales : les quintiles en abscisse, de Q1 à Q5, la part des adolescents (%) en ordonnée, avec un axe qui commence à 0.
2. Exemple : « Ce graphique présente la part des adolescents de 11 à 15 ans qui boivent au moins une boisson sucrée par jour selon l'aisance de leur famille (enquête régionale, 2025, n = 2 500). Cette part diminue régulièrement quand l'aisance de la famille augmente, de 4 à 5 points à chaque quintile. Elle passe de 38 % chez les adolescents des familles les moins aisées à 19 % chez ceux des familles les plus aisées. L'écart est de 19 points : la consommation quotidienne est deux fois plus fréquente (38 / 19 = 2,00) dans le premier quintile que dans le dernier. Ce gradient social s'explique notamment par le prix et la disponibilité des boissons, le marketing et les habitudes familiales ; il justifie des actions renforcées auprès des familles modestes, en plus d'actions sur l'offre (fontaines à eau, distributeurs). »
3. Limites : données déclarées par les adolescents (sous-déclaration possible) ; « au moins une boisson par jour » ne dit rien des quantités ; données d'une seule année ; il manque la marge d'erreur de chaque groupe (500 adolescents par quintile).

Corrigé – Exercice 2.45

1. Coût de la portion : lentilles 0,070 × 3,20 = 0,22 € ; poulet 0,120 × 11,90 = 1,43 € ; sardines 1,35 € ; œufs 2 × 0,30 = 0,60 € ; tofu 0,125 × 9,95 = 1,24 €.
2. Protéines de la portion = quantité × teneur / 100 : lentilles 70 × 27,7 / 100 = 19,4 g ; poulet 120 × 23,4 / 100 = 28,1 g ; sardines 95 × 23,3 / 100 = 22,1 g ; œufs 100 × 12,8 / 100 = 12,8 g ; tofu 125 × 13,4 / 100 = 16,8 g.
3. Coût de 20 g de protéines = coût de la portion × 20 / protéines : lentilles 0,22 × 20 / 19,4 = 0,23 € ; œufs 0,60 × 20 / 12,8 = 0,94 € ; poulet 1,43 × 20 / 28,1 = 1,02 € ; sardines 1,35 × 20 / 22,1 = 1,22 € ; tofu 1,24 × 20 / 16,8 = 1,49 €. Classement : lentilles, œufs, poulet, sardines, tofu. Les lentilles sont environ quatre fois moins chères que les œufs pour la même quantité de protéines. (Calculs faits avec les valeurs non arrondies.)
4. Vigilance : associer les légumineuses à des céréales dans la journée pour la complémentarité des acides aminés ; associer une source de vitamine C pour améliorer l'absorption du fer non héminique ; augmenter progressivement les quantités pour la tolérance digestive. Astuce : les lentilles corail cuisent en 15 minutes sans trempage, ce qui convient aux familles qui ont peu de temps ou d'énergie (gaz, électricité).
5. Les aliments n'apportent pas la même quantité de protéines pour un même poids et ne se consomment pas dans les mêmes quantités. Le coût de 20 g de protéines compare ce qui intéresse vraiment la famille : le prix d'un même apport nutritionnel.

Corrigé – Exercice 2.46

1. L'évaluation d'impact sur la santé est une démarche structurée qui estime, avant une décision prise hors du secteur de la santé, ses effets potentiels sur la santé de la population et sur la répartition de ces effets (inégalités), puis formule des recommandations. La santé dans toutes les politiques (déclaration d'Helsinki, OMS, 2013) consiste à prendre en compte la santé dans les décisions de tous les secteurs : urbanisme, transport, éducation, agriculture.

2. Effets positifs : 18 emplois (le revenu est un déterminant de santé), lieu de sociabilité pour les jeunes. Effets négatifs : plus d'offre de restauration rapide dans un quartier qui en compte déjà 7 et aucun primeur (marais alimentaire) ; tentation pour les 34 % d'élèves externes et pour tous à la sortie des cours ; perte du jardin partagé (activité physique, lien social, éducation alimentaire) ; trafic automobile du drive près d'un collège. Groupes concernés : collégiens, surtout externes ; habitants qui comptaient sur le jardin ; familles modestes plus sensibles aux prix bas.

3. Conditions socio-économiques générales : règles d'urbanisme qui limitent la restauration rapide près des établissements scolaires. Conditions de vie : maintien du jardin partagé ou installation d'un primeur. Réseaux sociaux : ateliers du jardin avec le centre social et les familles. Mode de vie : éducation alimentaire au collège sur le marketing et les choix à petit prix.

4. Recommandations : implanter le restaurant ailleurs, à plus de 500 m du collège ; maintenir le jardin partagé sur le terrain ; si le projet est maintenu, demander à l'enseigne de ne pas faire de promotion visant les collégiens et intégrer un projet d'offre de fruits et légumes dans le quartier.

5. Le diététicien apporte son expertise sur l'environnement alimentaire, les comportements alimentaires des adolescents et les publics vulnérables ; il propose des indicateurs de suivi.

Corrigé – Exercice 2.47

1. Mortalité infantile = 41 / 9 820 × 1 000 = 4,18 ‰. Mortalité néonatale = 27 / 9 820 × 1 000 = 2,75 ‰.

2. 27 / 41 × 100 = 65,9 % des décès avant 1 an surviennent avant 28 jours.

3. Prématurité : 742 / 9 820 × 100 = 7,6 %. Petit poids de naissance : 708 / 9 820 × 100 = 7,2 %. Allaitement à la sortie de la maternité : 6 540 / 9 820 × 100 = 66,6 %.

4. Actions : ateliers sur l'alimentation de la femme enceinte (prise de poids adaptée, folates, fer, iode, arrêt de l'alcool), en lien avec la PMI et les sages-femmes ; soutien à l'allaitement (consultations de lactation, groupes de mères, information des pères) ; ateliers sur la diversification alimentaire de 4 à 6 mois.

5. Le nombre de décès est petit (41) : quelques décès de plus ou de moins changent fortement le taux. On le calcule sur trois ans et on le compare à la moyenne nationale (environ 4 ‰) avec prudence. Il dépend aussi de facteurs non nutritionnels (malformations, accès aux maternités).

Corrigé – Exercice 2.48

Partie A – Diagnostic

1. Boursiers : 128 / 312 × 100 = 41,0 %. Non-boursiers : 171 / 228 × 100 = 75,0 %. Ensemble : 299 / 540 × 100 = 55,4 %. Écart absolu : 75,0 − 41,0 = 34,0 points. Écart relatif : 75,0 / 41,0 = 1,83 : les non-boursiers sont 1,83 fois plus souvent inscrits que les boursiers, alors que ce sont les boursiers qui en ont le plus besoin.

2. 63 / 210 × 100 = 30,0 % des élèves ne prennent pas de petit-déjeuner au moins 3 jours sur 5.

3. R1 = 34 / 63 = 54,0 % ; R0 = 41 / 147 = 27,9 % ; RR = 0,540 / 0,279 = 1,93 ; DR = 54,0 − 27,9 = 26,1 points. Les élèves sans petit-déjeuner déclarent près de deux fois plus souvent une fatigue en fin de matinée. C'est une enquête transversale et déclarative : l'association peut s'expliquer aussi par le sommeil, les écrans ou le départ très tôt des parents (facteurs de confusion).

4. Surpoids : 31 / 128 × 100 = 24,2 % ; obésité : 9 / 128 × 100 = 7,0 %. Marge d'erreur du surpoids : 1,96 × √(0,242 × 0,758 / 128) = 0,074, soit ± 7,4 points (16,8 % à 31,6 %). La prévalence est supérieure aux données nationales Esteban 2015 (17 % de surpoids, dont 4 % d'obésité, chez les 6-17 ans), mais l'intervalle de confiance (16,8 % à 31,6 %) contient la valeur nationale de 17 % : avec 128 élèves, la

différence n'est pas démontrée et le constat doit être confirmé sur plusieurs années.

5. Mode de vie : élèves sans petit-déjeuner, achats de chips et de sodas. Réseaux sociaux : les copains rentrent chez eux, effet de groupe. Conditions de vie et de travail : mère au travail dès 6 h, épicerie en face du collège, dossiers de tarif réduit en français et à des horaires restreints, menus mal connus. Conditions générales : emploi précaire à horaires décalés, politique de tarification de la restauration scolaire.

Partie B – Proposition d'action

6. Problème prioritaire : « Les élèves boursiers du collège des Peupliers sont peu inscrits à la demi-pension (41,0 % contre 75,0 %) et 30 % des élèves ne prennent pas de petit-déjeuner régulièrement, ce qui limite leurs apports alimentaires de la matinée et du midi. » Public : les élèves de 6e et de 5e et leurs familles, en priorité les familles boursières, parce que l'écart d'accès à la cantine est la principale inégalité et que les habitudes se prennent à l'entrée au collège.

7. Objectif général : améliorer l'alimentation du matin et du midi des élèves du collège des Peupliers, en réduisant l'écart d'accès à la demi-pension entre boursiers et non-boursiers. Objectifs spécifiques : d'ici juin 2027, faire passer le taux d'inscription des élèves boursiers à la demi-pension de 41,0 % à 55 % ; d'ici juin 2027, faire passer la part des élèves de 5e et 4e sans petit-déjeuner au moins 3 jours sur 5 de 30,0 % à 22 % ; d'ici mars 2027, que 60 familles boursières aient participé à au moins un atelier ou une permanence d'information.

8. Actions : 1) environnement et accès (action renforcée pour les boursiers) : simplifier le dossier de tarif réduit (traduction, aide au remplissage lors de permanences le soir et le samedi avec l'assistante sociale), offrir deux repas découverte aux élèves boursiers non inscrits, afficher les menus en images ; 2) petit-déjeuners pédagogiques en classe de 6e et de 5e (pour tous), avec un travail sur des petits-déjeuners rapides à préparer seul ; 3) ateliers cuisine parents-élèves au collège ou au centre social, à des horaires adaptés au travail décalé (fin d'après-midi, samedi matin), gratuits.

9. Budget (exemple) : 8 petits-déjeuners pédagogiques, 8 × 26 élèves × 0,85 € = 176,80 € ; ingrédients de 6 ateliers cuisine, 6 × 45 € = 270,00 € ; intervention d'une diététicienne, 20 h × 45 € = 900,00 € ; repas découverte pour 120 élèves boursiers non inscrits, 120 × 2 × 3,40 € = 816,00 € ; matériel (blender, ustensiles) 420,00 € ; communication et traduction des supports 350,00 € ; formation de l'équipe de cantine et des surveillants, 2 séances de 3 h à 45 €, 270,00 € ; supports d'évaluation 80,00 € ; total 3 282,80 €, réserve pour imprévus 717,20 €, soit 4 000,00 €.

Partie C – Évaluation et éthique

10. Indicateurs : processus, nombre de familles reçues en permanence et de dossiers de tarif réduit déposés ; processus, nombre d'élèves ayant participé aux petits-déjeuners ; résultat, taux d'inscription des boursiers à la demi-pension en juin 2027 (cible 55 %) ; inégalités, écart absolu et relatif d'inscription entre boursiers et non-boursiers avant et après (34,0 points et 1,83 au départ) ; résultat, part d'élèves sans petit-déjeuner au même questionnaire en juin 2027.

11. Précautions : ne jamais désigner publiquement les élèves boursiers ni les élèves en surpoids (actions ouvertes à tous, données agrégées, anonymat du questionnaire) ; ne pas culpabiliser les parents qui travaillent tôt (valoriser les solutions simples), obtenir l'accord des familles et respecter la confidentialité des données de santé (RGPD).

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Présenter les modèles de Lalonde, de Dahlgren et Whitehead et de la CDSS ; analyser les déterminants de l'alimentation	2.1 à 2.6			
2	Définir les inégalités sociales de santé et le gradient ; calculer un écart absolu et relatif ; appliquer l'universalisme proportionné	2.7 à 2.12			
3	Lire une pyramide ; calculer natalité, soldes, indicateurs de vieillissement ; interpréter l'espérance de vie	2.13 à 2.18			
4	Calculer des taux de mortalité ; standardiser (méthodes directe et indirecte) ; distinguer prévalence et incidence	2.19 à 2.24			
5	Trouver une source ; calculer un IMC et des prévalences ; calculer une marge d'erreur ; construire un portrait de territoire	2.25 à 2.30			
6	Expliquer les transitions ; calculer des AVCI et des cas attribuables ; argumenter la priorité nutritionnelle	2.31 à 2.36			
7	Calculer RR, DR, OR et fractions attribuables ; repérer un facteur de confusion ; discuter la causalité	2.37 à 2.42			
8	Choisir un graphique et commenter des données ; calculer le coût des protéines ; conduire une EIS ; traiter un cas complet	2.43 à 2.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5

02

CHAPITRE

02

Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé

Déterminants de santé | Inégalités | Mesure de l'état de santé

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 2 209
Mode d'emploi du cahier d'annales 209
Ce que le jury attend sur ce chapitre 209
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 210
S1 – « Récolter sans s'oublier » : la santé des saisonniers agricoles d'une vallée arboricole 210
S2 – « Cuisiner sans cuisine » : un atelier pour des familles hébergées à l'hôtel 213
S3 – Vivre avec un trouble psychique et bien manger : un groupe d'entraide mutuelle 216
Partie II – Les corrigés détaillés 219
Corrigé S1 – « Récolter sans s'oublier » : la santé des saisonniers agricoles 219
Corrigé S2 – « Cuisiner sans cuisine » : un atelier pour des familles hébergées à l'hôtel 225
Corrigé S3 – Vivre avec un trouble psychique et bien manger : un groupe d'entraide mutuelle 230
Grille d'auto-évaluation 235

Cahier d'annales E5 – chapitre 2

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes et les données des territoires sont fictives : elles sont construites pour l'entraînement et ne doivent pas être citées comme des données réelles. Les données nationales sont réelles et datées. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Récolter sans s'oublier » : la santé des saisonniers agricoles d'une vallée arboricole	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Cuisiner sans cuisine » : un atelier pour des familles hébergées à l'hôtel	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	Vivre avec un trouble psychique et bien manger : un groupe d'entraide mutuelle	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 2 donne les outils du diagnostic : les déterminants de santé (modèles de Lalonde, de Dahlgren et Whitehead, de la Commission des déterminants sociaux de l'OMS), les inégalités sociales et territoriales de santé, et les indicateurs qui mesurent l'état de santé d'une population (taux bruts et standardisés, mortalité prématurée et évitable, prévalence, incidence, risque relatif). Le jury vérifie que le candidat ne se contente pas de « constater » : il doit expliquer les écarts par des déterminants, choisir des indicateurs adaptés, savoir qu'un taux brut peut tromper quand les populations n'ont pas la même structure d'âge, et proposer des actions qui réduisent les écarts (universalisme proportionné) sans stigmatiser.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; surligner les chiffres, le public, les contraintes et le verbe de chaque consigne. Pendant : pour chaque indicateur, écrire la formule, l'application numérique, le résultat avec son unité, puis une phrase d'interprétation qui nomme un déterminant. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Récolter sans s'oublier » : la santé des saisonniers agricoles d'une vallée arboricole

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II).

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année au service d'action sanitaire et sociale de la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) Vallée du Lorvan (structure et territoire fictifs). Chaque année, de juin à octobre, environ 2 400 travailleurs saisonniers viennent récolter les cerises, les abricots puis les pommes dans les vergers de la vallée. La responsable prévention vous confie une demande : « Les employeurs nous signalent des malaises dans les vergers dès 10 heures du matin, surtout pendant les fortes chaleurs. Les infirmières du service de santé au travail disent que beaucoup de saisonniers ne mangent presque rien de la journée. Nous voulons un projet de prévention pour la saison prochaine, mais nous ne savons pas par où commencer. » Vous devez poser le diagnostic, concevoir le projet, en réaliser une partie pendant votre stage et en rendre compte dans votre dossier E5.

Document 1 – La structure, le public et les moyens

- Service d'action sanitaire et sociale de la MSA : une responsable prévention, deux travailleuses sociales, un camion de prévention aménagé (table, réfrigérateur, bouilloire, écran) qui peut se rendre dans les exploitations à l'heure de la pause.
- Partenaires possibles : service de santé au travail de la MSA (médecin et deux infirmières), syndicat des producteurs de fruits de la vallée (48 exploitations), deux campings municipaux qui hébergent des saisonniers, l'épicerie solidaire du bourg (ouverte le mardi et le samedi), la maison de santé pluriprofessionnelle.
- Public : saisonniers de 18 à 64 ans ; 38 % ne parlent pas ou peu le français (principalement l'espagnol, le roumain, l'arabe ou le portugais) ; beaucoup vivent dans leur voiture, en tente ou en mobil-home ; journées de 7 à 9 heures de travail physique, en extérieur, de 6 h 30 à 14 h 30 lors des épisodes de chaleur.
- Budget : 3 000 € accordés par le fonds de prévention de la MSA pour la saison, matériel compris.

Document 2 – Mortalité du canton du Lorvan et du département (données fictives construites pour le sujet, population de 15 ans et plus)

Tranche d'âge	Population du canton	Décès dans le canton (moyenne annuelle 2021-2023)	Taux de mortalité du département (pour 1 000)
15-44 ans	9 200	9	0,8
45-64 ans	7 400	37	4,2
65 ans et plus	5 900	262	38,5
Total	22 500	308	taux brut du département : 10,9 ‰

Autres indicateurs (observatoire régional de la santé, données fictives) : part des ouvriers parmi les actifs du canton : 31 % (département : 22 %) ; part des 15 ans et plus sans diplôme : 29 % (département : 21 %) ; densité de médecins généralistes : 6,1 pour 10 000 habitants (département : 8,4).

Document 3 – Enquête menée par les infirmières pendant la saison 2026 (données fictives)

Questionnaire traduit en quatre langues, proposé lors des visites du camion de prévention dans 11 exploitations ; 186 saisonniers ont répondu.

Question (sur la semaine précédente, sauf mention)	Nombre de « oui » (n = 186)
Logé sans moyen de cuisson (ni plaque, ni four, ni réchaud)	74
A sauté au moins un repas, au moins 3 jours de travail sur 7	81
A bu au moins une boisson énergisante par jour	63
A mangé des fruits ou des légumes chaque jour	58
A eu un malaise ou une sensation de faiblesse au travail pendant la saison	29
Souhaite des idées de repas simples, pas chers et transportables	112

Croisement réalisé par les infirmières : parmi les 74 saisonniers logés sans moyen de cuisson, 47 ont sauté au moins un repas 3 jours sur 7 ; parmi les 112 qui ont un moyen de cuisson, 34 l'ont fait.

Document 4 – Ce qu'ils disent (entretiens menés avec une interprète)

« Je mange une barre et un energy le matin, après je n'ai plus faim jusqu'au soir. » (Andrei, 27 ans)

« Les fruits, on les cueille toute la journée, mais on n'a pas le droit d'en manger, et le soir on n'en achète pas. » (Lucía, 34 ans)

« Dans la voiture, rien ne reste frais. » (Karim, 41 ans)

« Le supermarché est à 14 kilomètres. Quand on rentre, il est fermé. » (Ana, 22 ans)

« Avant de venir ici, je ne savais pas qu'il fallait boire autant. » (Mihai, 19 ans)

« Mon patron nous donne des bouteilles d'eau, c'est déjà bien. » (Youssef, 52 ans)

Document 5 – Une proposition reçue par la MSA

Un fabricant de boissons énergisantes propose d'offrir gratuitement 3 000 canettes « pour soutenir les saisonniers pendant les fortes chaleurs », en échange de son logo sur les affiches du projet. Par ailleurs, un employeur demande que les infirmières lui transmettent la liste des saisonniers « qui ont fait des malaises », pour « ne plus les embaucher sur les postes en hauteur ».

Document 6 – Données nationales et cadre des politiques publiques (données réelles)

- À 35 ans, un homme cadre peut espérer vivre encore 48,9 ans, un homme ouvrier 43,6 ans (Insee Première n° 2005, juillet 2024, données 2020-2022).
- Le 4e plan santé au travail (PST 4) couvre la période 2021-2025 ; la prévention des risques liés aux fortes chaleurs fait l'objet de recommandations du ministère du Travail chaque été.
- Le programme national nutrition santé 2026-2030 (PNNS 5) a été lancé le 8 avril 2026 ; la réduction des inégalités sociales de santé en nutrition en est une priorité.
- La Mutualité sociale agricole gère la protection sociale des salariés et des exploitants agricoles et conduit des actions de prévention (santé au travail, action sanitaire et sociale).

Travail à faire

Partie A – Le projet d'intervention (dossier écrit de 10 pages au plus) – C3.1 (9 points)

1. Classez les déterminants de la santé des saisonniers selon le modèle de Dahlgren et Whitehead (1991), en vous appuyant sur les documents 1, 3 et 4. Montrez qu'il s'agit d'une situation d'inégalité sociale de santé. (1,5 pt)
2. Avec le document 2, calculez le taux brut de mortalité du canton, puis le nombre de décès attendus et le rapport standardisé de mortalité (méthode indirecte). Interprétez en expliquant pourquoi le taux brut ne suffit pas. (2 pts)
3. Calculez les indicateurs de l'enquête (document 3) et le taux de participation ; posez le diagnostic en distinguant les besoins (Bradshaw) ; formulez le problème central. (1,5 pt)
4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et des objectifs opérationnels, chacun avec un indicateur, une valeur cible et une échéance. (1,5 pt)
5. Présentez le plan d'action sur la saison (actions, lieux, horaires, partenaires) et un budget qui respecte les 3 000 €. Montrez comment le projet applique l'universalisme proportionné. (1,5 pt)
6. Construisez la démarche d'évaluation (processus, résultats) et proposez la valorisation du projet. (1 pt)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée – C3.3 (3 points)

7. Calculez le risque relatif de sauter des repas selon le logement (document 3) et interprétez-le. Peut-on conclure que l'absence de moyen de cuisson est la cause du saut de repas ? (1,5 pt)
8. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion de saisonniers qui sautent des repas, puis la taille d'échantillon nécessaire pour une précision de ± 5 points (avec correction pour une population de 2 400). Citez trois biais de l'enquête. (1,5 pt)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

9. Organisez une veille sur la santé et l'alimentation des travailleurs exposés à la chaleur : sources fiables, outils, fréquence, diffusion. (2 pts)

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique – C3.5 et C3.6 (3 points)

10. Analysez les deux demandes du document 5 et rédigez la réponse de la MSA. (1,5 pt)
11. Proposez des supports de communication adaptés à un public allophone en situation de précarité ; rédigez la trame minutée de votre exposé de 10 minutes et listez 15 questions probables du jury. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Cuisiner sans cuisine » : un atelier pour des familles hébergées à l'hôtel

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des sujets U62 et E5.B (bon de commande, fiche technique, organisation dans le temps, hygiène) et du BTS blanc CNED E5B (adaptation d'une recette et calcul nutritionnel).

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'accueil de jour « Le Relais des familles » de la ville de Montaury (structure fictive) reçoit des familles sans logement hébergées par le service intégré d'accueil et d'orientation dans des chambres d'hôtel. Dans ces chambres, il est interdit de cuisiner ; les familles disposent au mieux d'une bouilloire et, pour certaines, d'un four à micro-ondes prêté par l'association. L'équipe constate que les familles achètent surtout des plats tout prêts, des biscuits et des boissons sucrées, et que les mères disent manquer d'énergie. Elle vous demande de concevoir et d'animer un atelier « Cuisiner sans cuisine » : les participants cuisinent à l'accueil de jour, mangent ensemble, puis repartent avec des recettes qu'ils peuvent refaire à l'hôtel avec une bouilloire et un four à micro-ondes.

Document 1 – Le public et les contraintes

- 8 parents (7 mères, 1 père) de 22 à 46 ans ; 2 mères enceintes (5e et 7e mois) ; 1 mère allaite un bébé de 4 mois ; plusieurs familles ne mangent pas de porc ; une mère signale que son fils de 6 ans est allergique au lait de vache (il ne participe pas à l'atelier, mais elle veut refaire la recette).
- Langues : français, arabe, tigrigna, géorgien ; une interprète bénévole est présente pour l'arabe.
- Atelier : cuisine de l'accueil de jour (2 plaques à induction, 1 four, 2 fours à micro-ondes, 2 bouilloires, 1 réfrigérateur, 4 postes de travail pour 2 personnes).
- Budget denrées : au plus 1,50 € par portion ; 10 portions (8 parents et 2 professionnels).
- Durée de l'atelier avec le public : 2 heures, de 10 h 00 à 12 h 00, repas compris. Le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 2 – Menu imposé

Plat : dahl de lentilles corail aux carottes et à la tomate, graine de couscous.

Dessert : compote de pommes minute au four à micro-ondes et yaourt nature.

Le candidat réalise le plat. Il présente aussi la « version hôtel » de chaque préparation (bouilloire et four à micro-ondes seulement) et une adaptation pour l'enfant allergique au lait de vache.

Document 3 – Grammages nets par portion, pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Grammage net par portion	Perte au parage ou à l'épluchage	Prix
Lentilles corail sèches	50 g	sans perte	3,20 € le kg
Carottes	60 g	15 %	1,40 € le kg
Oignons	20 g	10 %	1,80 € le kg
Tomates pelées au jus, en boîte	80 g	sans perte	2,20 € le kg
Huile de colza	5 g	sans perte	3,20 € le litre (1 L = 920 g)

Denrée	Grammage net par portion	Perte au parage ou à l'épluchage	Prix
Graine de couscous précuite	60 g	sans perte	1,90 € le kg
Pommes	100 g	20 %	2,40 € le kg
Yaourt nature (pot de 125 g)	1 pot	sans perte	0,20 € le pot
Épices (curcuma, cumin, gingembre), ail, citron	–	–	forfait 0,80 € pour l'atelier

Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte).

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Fer (mg)	Calcium (mg)
Lentille corail, sèche	328	27,7	44,9	0,8	15,4	6,3	29
Carotte, crue	30,2	0,78	5,16	< 0,5	2,9	< 0,25	36,2
Oignon, cru	39	1,1	6,25	0,62	1,7	0,00019	25
Tomate, pelée, appertisée, au jus, non égouttée	21,8	0,79	3,15	0,25	1,9	0,57	33
Huile de colza	900	0	0	100	0	0,023	< 2,57
Graine de couscous (semoule de blé dur précuite), à cuire	366	12,3	72,7	1,32	4,5	1,08	24
Pomme, chair sans peau, bouillie/cuite à l'eau	54	0,26	11,2	0,36	2,4	0,19	5
Yaourt ou lait fermenté, nature	50,1	3,83	4,26	1,68	traces	< 0,25	137

On calcule avec les poids nets crus (secs pour les lentilles et la graine de couscous). Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. Les épices sont négligées. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (fichier du 3 novembre 2025, mis en ligne le 19 novembre 2025) ; le fer de l'oignon (0,00019 mg) est négligeable.

Document 5 – Repères utiles (données réelles)

- Références nutritionnelles de l'ANSES (2021) : besoin en fer de 11 mg par jour pour une femme adulte ayant des pertes menstruelles faibles à normales ; 30 g de fibres par jour pour un adulte.
- Pendant la grossesse, on évite les produits au lait cru, la viande et le poisson crus ou peu cuits ; on lave soigneusement les légumes et les herbes (listériose, toxoplasmose) (Santé publique France, repères pour les femmes enceintes).
- L'enquête ENFAMS (Observatoire du Samusocial de Paris, 2014) a montré que près de huit familles sans logement sur dix, hébergées en Île-de-France, étaient en situation d'insécurité alimentaire.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (11 points)

1. Identifiez les besoins du public et formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier. (2 pts)

2. Établissez le bon de commande pour 10 portions (quantités nettes, quantités brutes, unités de commande, coût) ; calculez le coût par portion et vérifiez le respect du budget. (2 pts)

3. Rédigez la fiche technique du dahl (ingrédients, matériel, étapes, points critiques) et la fiche « version hôtel » (bouilloire et micro-ondes) ; proposez l'adaptation sans lait de vache du dessert. (3 pts)

4. Calculez l'apport d'une portion du plat et du repas complet (énergie, protéines, glucides, lipides, fibres, fer, calcium) ; calculez la part des besoins en fer et en fibres couverte par le repas pour une femme adulte ; commentez pour les femmes enceintes. (2 pts)

5. Montrez en quoi cet atelier agit sur des déterminants de santé de ces familles, et en quoi il ne suffit pas à réduire les inégalités. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et participants) en tenant compte de la langue et des enfants. (2 pts)

7. Présentez les méthodes d'animation, les outils adaptés (faible littératie, langues) et une grille de dégustation sans texte. (1,5 pt)

8. Présentez les règles d'hygiène (5 M), la conservation des restes à l'hôtel sans réfrigérateur, les allergènes et trois éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

9. Réalisez le dahl et la version hôtel du dessert ; dressez deux assiettes. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier (satisfaction, acquis, intention de refaire). (1 pt)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Vivre avec un trouble psychique et bien manger : un groupe d'entraide mutuelle

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet mixte – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) sur une même situation

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : 30 min d'oral préparé (temps 1) et 3 h (temps 2) · Barème : 20 points par temps.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique au groupe d'entraide mutuelle (GEM) « L'Escale » de la ville de Rocheval (structure fictive). Un GEM est une association d'usagers, prévue par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, qui accueille des adultes vivant avec un trouble psychique pour rompre l'isolement et favoriser l'entraide ; ce sont les adhérents qui décident des activités. Le GEM compte 48 adhérents ; il est ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 18 h et dispose d'une cuisine équipée. Lors de l'assemblée des adhérents, plusieurs personnes ont demandé « un atelier pour bien manger sans se ruiner, parce que les médicaments font grossir ». L'animatrice coordinatrice vous confie le projet.

Document 1 – Données réelles sur la santé des personnes vivant avec un trouble psychique sévère

- Les personnes suivies pour un trouble psychique sévère ont une espérance de vie réduite d'environ 16 ans pour les hommes et 13 ans pour les femmes, et leur mortalité prématurée est environ quatre fois plus élevée que celle de la population générale (Coldefy et Gandré, Irdes, Questions d'économie de la santé n° 237, septembre 2018).
- Les maladies cardiovasculaires et métaboliques, favorisées par le tabagisme, la sédentarité, l'alimentation et certains traitements antipsychotiques, sont une cause majeure de cette surmortalité.
- Les projets territoriaux de santé mentale (PTSM), prévus par la loi du 26 janvier 2016, organisent le parcours des personnes sur chaque territoire ; la santé somatique des personnes vivant avec un trouble psychique en est un axe.
- Dans l'étude ESTEBAN (Santé publique France, mesures 2014-2016, publication 2017), 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient en situation d'obésité.

Document 2 – Enquête menée au GEM (données fictives)

36 adhérents sur 48 ont répondu à un questionnaire lu à voix haute en petit groupe. Par ailleurs, 30 de ces 36 répondants ont accepté, par écrit, que l'infirmière du centre médico-psychologique partenaire mesure leur poids et leur taille : 12 d'entre eux ont un IMC de 30 kg/m² ou plus.

Question	Nombre de « oui » (n = 36)
Saute au moins un repas par jour, au moins 4 jours sur 7	15
Mange un plat préparé du commerce ou de la restauration rapide au moins 4 fois par semaine	19
Boit au moins 1 litre de boisson sucrée par jour	11
Mange des fruits ou des légumes chaque jour	10
Fume chaque jour	21
Prend un traitement dont il dit qu'il « fait grossir »	22
Souhaite participer à un atelier cuisine	27

Document 3 – Moyens et contraintes

Budget accordé par l'agence régionale de santé dans le cadre du PTSM : 1 200 € pour l'année. Cuisine du GEM : 4 plaques, 1 four, 1 four à micro-ondes, 1 réfrigérateur, 3 postes de travail. Contraintes signalées par l'animatrice : difficultés de concentration chez certains adhérents (séances courtes), fatigue en début de matinée liée aux traitements, petit budget personnel (allocation aux adultes handicapés), peur du regard des autres au supermarché.

Travail à faire – Temps 1

1. Calculez les indicateurs de l'enquête, le taux de réponse et le rapport entre la prévalence de l'obésité au GEM et celle de la population générale ; présentez les limites de cette comparaison. (4 pts)
2. Expliquez cette situation par les déterminants de santé (individuels, liés aux soins, sociaux) ; montrez en quoi il s'agit d'une inégalité de santé. (3 pts)
3. Formulez les objectifs (général, spécifiques, opérationnels) et le plan d'action sur 12 mois, en respectant le principe d'autodétermination des adhérents du GEM. (5 pts)
4. Présentez la démarche d'évaluation et un budget qui respecte les 1 200 €. (3 pts)
5. Indiquez les précautions éthiques et juridiques liées aux données de santé (poids, traitements) recueillies au GEM, et les règles de communication sur le projet (photos, réseaux sociaux). (3 pts)
6. Expression et sources. (2 pts)

Travail à faire – Temps 2

Document 4 – Atelier imposé et données (prix construits pour le sujet ; composition : table Ciqual 2025, ANSES, 19 novembre 2025)

Atelier de 1 h 30 pour 8 adhérents (dont 2 végétariens qui mangent des œufs et des produits laitiers), de 11 h 00 à 12 h 30, suivi du repas pris ensemble. Coût des denrées : au plus 2,50 € par portion. Menu : omelette aux courgettes et aux poivrons ; pommes de terre rôties au four ; pain complet ; fromage blanc aux framboises.

Grammages nets par portion : 2 œufs (100 g sans coquille) ; courgette 100 g (5 % de perte) ; poivron 50 g (20 % de perte) ; pommes de terre 200 g (20 % de perte à l'épluchage) ; huile de colza 10 g en tout (5 g pour l'omelette, 5 g pour les pommes de terre) ; pain complet 40 g ; fromage blanc 3 % MG 100 g ; framboises surgelées 80 g.

Prix : œufs 0,28 € pièce ; courgettes 2,20 € le kg ; poivrons 3,50 € le kg ; pommes de terre 1,20 € le kg ; huile de colza 3,20 € le litre (1 L = 920 g) ; pain complet 4,20 € le kg ; fromage blanc 2,60 € le kg ; framboises surgelées 7,50 € le kg ; sel, poivre, herbes : forfait 0,60 € pour l'atelier.

Aliment (libellé Ciqual 2025), pour 100 g	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Oeuf cru	140	12,8	0,06	9,83	0	0,31
Courgette, chair et peau, crue	16,7	1,21	1,75	0,32	1	0,02
Poivron, vert, jaune ou rouge, cru	22,6	0,8	3,5	0,27	1,5	0,021
Pomme de terre, sans peau, crue	80	2,02	16,2	0,09	2,2	< 0,0011
Huile de colza	900	0	0	100	0	< 0,0028
Pain complet ou intégral (à la farine T150)	234	8,66	41,2	1,7	7,3	1,17
Fromage blanc, nature, 2-3% MG	75,7	7,28	3,86	3,23	0,019	0,088
Framboise, crue	47,9	1,19	5,83	0,8	4,3	< 0,013

> On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < » est comptée 0. La table ne donne pas de valeur pour les framboises surgelées : on utilise la framboise crue.

7. Identifiez les besoins et les objectifs de l'atelier ; justifiez le choix du menu au regard du public (budget, fatigue, traitements, autonomie). (3 pts)

8. Établissez le bon de commande et la fiche technique de l'omelette pour 8 portions ; calculez l'apport du repas complet (énergie, protéines, glucides, lipides, fibres, sel) et la part de l'énergie apportée par les lipides. (5 pts)

9. Présentez le déroulé de l'atelier (séquences courtes), les techniques d'animation et la grille de dégustation. (4 pts)

10. Présentez les règles d'hygiène (œufs, cuisson, refroidissement des restes, allergènes) et les éco-gestes. (4 pts)

11. Réalisez les préparations et évaluez l'atelier. (4 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Récolter sans s'oublier » : la santé des saisonniers agricoles

que le jury attend

Le jury évalue une démarche de diagnostic rigoureuse : des indicateurs calculés et interprétés, des écarts expliqués par des déterminants nommés, des besoins classés, puis un projet réaliste qui tient compte des horaires, des langues et des conditions de logement. Il pénalise le discours moralisateur (« ils devraient manger mieux »), l'oubli des déterminants liés au travail et au logement, et toute proposition qui exposerait les saisonniers à une discrimination.

Partie A – Le projet d'intervention

Question 1 – Les déterminants selon Dahlgren et Whitehead (1,5 pt)

Niveau du modèle (1991)	Déterminants repérés dans les documents
Facteurs individuels non modifiables	Âge (18 à 64 ans), sexe ; vulnérabilité à la chaleur plus grande avec l'âge
Comportements et modes de vie	Repas sautés, boissons énergisantes le matin, peu de fruits et légumes, hydratation insuffisante (« je ne savais pas qu'il fallait boire autant »)
Réseaux sociaux et communautaires	Isolement loin de la famille, barrière de la langue (38 % parlent peu ou pas le français), entraide entre collègues
Conditions de vie et de travail	Travail physique de 7 à 9 h en extérieur, chaleur, horaires décalés (6 h 30 – 14 h 30) ; logement en voiture, en tente ou en mobil-home, sans moyen de cuisson ni de froid (39,8 %) ; supermarché à 14 km, fermé au retour ; faible densité de médecins (6,1 contre 8,4 pour 10 000)
Conditions socio-économiques, culturelles et environnementales	Emploi précaire et saisonnier, faibles revenus, part élevée d'ouvriers (31 % contre 22 %) et de personnes sans diplôme (29 % contre 21 %), épisodes de chaleur liés au changement climatique

C'est une **inégalité sociale de santé** : la santé des saisonniers est moins bonne que celle de la population générale, cet écart suit la position sociale (ouvriers agricoles précaires), il est **évitable** et **injuste** car il résulte de conditions de vie et de travail et non de choix individuels. Le document 6 rappelle le **gradient social** : à 35 ans, un ouvrier peut espérer vivre 5,3 ans de moins qu'un cadre (48,9 – 43,6 = 5,3 ans ; Insee, 2024). Il s'y ajoute une **inégalité territoriale** (canton rural, offre de soins plus faible).

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Placer « ne pas manger de fruits » uniquement dans les comportements sans relier au logement et au revenu ; oublier les conditions de travail ; parler d'« inégalité » pour toute différence (une différence liée à l'âge n'est pas une inégalité sociale).

Question 2 – Mortalité brute et standardisée (2 pts)

Calcul posé – Taux brut et rapport standardisé de mortalité (méthode indirecte)

Taux brut du canton = décès / population × 1 000 = 308 / 22 500 × 1 000 = **13,7 ‰** (département : 10,9 ‰).

Décès attendus = population de chaque tranche × taux du département / 1 000 :

- 15-44 ans : 9 200 × 0,8 / 1 000 = 7,36 ;
- 45-64 ans : 7 400 × 4,2 / 1 000 = 31,08 ;
- 65 ans et plus : 5 900 × 38,5 / 1 000 = 227,15 ;
- total attendu = 7,36 + 31,08 + 227,15 = **265,59 décès**.

Rapport standardisé de mortalité (RSM ou SMR) = décès observés / décès attendus = 308 / 265,59 = **1,16** (soit 116 sur une base 100).

Interprétation. Le taux brut du canton (13,7 ‰) est supérieur de 2,8 points à celui du département, mais une partie de cet écart vient de la **structure d'âge** : le canton compte beaucoup de personnes âgées (5 900 sur 22 500, soit 26,2 %), chez qui la mortalité est forcément plus élevée. Le RSM élimine cet effet : à structure d'âge identique, le canton compte **16 % de décès de plus** qu'attendu. Il existe donc une **surmortalité réelle**, cohérente avec les déterminants sociaux (part d'ouvriers, faible niveau de diplôme, moindre offre de soins). Limites : effectifs faibles dans les tranches jeunes (9 décès), moyenne sur trois ans, données qui concernent les résidents du canton et non les saisonniers eux-mêmes, qui ne sont pas recensés sur place.

Limites – Ce que le RSM ne dit pas

Le RSM compare le canton au département, pas aux saisonniers ; il ne donne pas les causes de décès ; un RSM de 1,16 doit être testé statistiquement (intervalle de confiance) avant d'affirmer une différence significative. À l'oral, dites : « Ce RSM est un signal qui justifie l'action ; il ne mesure pas l'état de santé des saisonniers. »

Question 3 – Indicateurs de l'enquête et diagnostic (1,5 pt)

Calcul posé – Indicateurs de l'enquête (n = 186)

- Logés sans moyen de cuisson : 74 / 186 × 100 = **39,8 %**.
- Repas sautés au moins 3 jours sur 7 : 81 / 186 × 100 = **43,5 %**.
- Boisson énergisante chaque jour : 63 / 186 × 100 = **33,9 %**.
- Fruits ou légumes chaque jour : 58 / 186 × 100 = **31,2 %**.
- Malaise ou faiblesse au travail dans la saison : 29 / 186 × 100 = **15,6 %**.
- Souhait d'idées de repas simples : 112 / 186 × 100 = **60,2 %**.

Taux de participation = 186 / 2 400 × 100 = **7,75 %** (environ 7,8 %).

Type de besoin (Bradshaw, 1972)	Dans la situation
Normatif	Repères PNNS non atteints (31,2 % seulement mangent fruits ou légumes chaque jour) ; malaises signalés par les infirmières ; recommandations du ministère du Travail sur la chaleur ; ANSES (2013) qui met en garde contre la consommation de boissons énergisantes, surtout à l'effort et en cas de chaleur
Ressenti	Fatigue, faim « coupée » par la boisson énergisante, sentiment de ne rien pouvoir conserver au frais
Exprimé	60,2 % demandent des idées de repas simples, pas chers et transportables
Comparatif	Les salariés logés avec cuisine sautent deux fois moins souvent des repas (question 7) ; les saisonniers n'ont pas accès aux commerces que les résidents utilisent

Problème central : pendant la saison, une part importante des saisonniers de la vallée (43,5 % des répondants) ne prend pas des repas suffisants et adaptés à un travail physique à la chaleur, ce qui les expose à des malaises et à des accidents. **Causes** : absence de moyen de cuisson et de froid, distance des commerces, horaires, revenus, méconnaissance des besoins en eau et en énergie, place des boissons énergisantes, barrière de la

langue. **Conséquences** : malaises, coups de chaleur, accidents (échelles), fatigue, baisse de revenu (travail payé au rendement).

Question 4 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : améliorer, pendant la saison 2027, l'alimentation et l'hydratation des saisonniers agricoles de la vallée du Lorvan afin de réduire les malaises au travail.
- **Objectif spécifique 1** : d'ici fin août 2027, réduire de 43,5 % à 30 % au plus la part des saisonniers enquêtés qui sautent au moins un repas 3 jours sur 7.
- **Objectif spécifique 2** : d'ici fin octobre 2027, réduire de 33,9 % à 20 % au plus la part des saisonniers qui boivent chaque jour une boisson énergisante.
- **Objectifs opérationnels** : réaliser 20 passages du camion de prévention à l'heure de la pause dans au moins 15 exploitations entre juin et septembre 2027 (indicateur : nombre de passages et d'exploitations, relevé dans le cahier de bord) ; distribuer 120 kits « repas au frais » aux saisonniers sans moyen de cuisson avant le 15 juillet (indicateur : nombre de kits remis, liste anonyme) ; diffuser en quatre langues une affiche et un dépliant illustré « Bien manger, bien boire à la chaleur » dans les 48 exploitations et les deux campings avant le 1er juin (indicateur : nombre de lieux couverts) ; obtenir l'engagement écrit de 10 exploitations à fournir un point d'eau fraîche et un espace d'ombre pour la pause (indicateur : nombre de chartes signées).

Question 5 – Plan d'action et budget (1,5 pt)

Action	Contenu	Lieu, horaire	Partenaires
1. « Le camion de la pause »	Dégustation de collations et repas froids simples (pain, fromage, œufs durs, fruits, légumes crus, conserves de légumineuses), eau aromatisée, messages sur l'hydratation, réponses aux questions	Dans les vergers, à la pause de 9 h 30 ou de 12 h	MSA, infirmières de santé au travail, interprète
2. Kits « repas au frais »	Sac isotherme, pain de glace, gourde, boîte, fiche de recettes sans cuisson en pictogrammes	Remis au camion et dans les campings	Campings, épicerie solidaire
3. Environnement de travail	Charte avec les employeurs : point d'eau, ombre, pause adaptée à la chaleur, fruits déclassés offerts	Exploitations	Syndicat des producteurs, service de santé au travail
4. Accès à l'alimentation	Ouverture de l'épicerie solidaire le mercredi soir pendant la saison ; navette du camping vers le bourg	Bourg	Commune, épicerie solidaire

Calcul posé – Budget prévisionnel (prix construits pour le sujet)

- Kits « repas au frais » : 120 × 12,50 € = 1 500,00 €.
- Denrées pour les dégustations : 10 passages × 60,00 € = 600,00 €.
- Interprète professionnelle (au-delà des bénévoles) : 6 h × 50,00 € = 300,00 €.
- Affiches et dépliants en quatre langues : 600 dépliants × 0,35 € = 210,00 € ; 20 affiches plastifiées × 6,00 € = 120,00 €.
- Glacière pour le camion : 90,00 €.
- Imprévus (6 %) : 180,00 €.

Total : 1 500 + 600 + 300 + 210 + 120 + 90 + 180 = **3 000,00 €**, soit exactement le budget.

Universalisme proportionné : tous les saisonniers bénéficient des messages, des affiches et des passages du camion (action universelle) ; les kits sont réservés en priorité aux saisonniers sans moyen de cuisson, les plus exposés (action proportionnée au besoin). Limite : 39,8 % de 2 400 saisonniers représentent environ 955 personnes ; 120 kits ne couvrent donc que 12,6 % d'entre elles (120 / 955 × 100) : il faut chercher un

cofinancement (employeurs, commune) et prioriser selon des critères transparents (pas de moyen de froid, plus de 50 ans, antécédent de malaise déclaré volontairement).

Question 6 – Évaluation et valorisation (1 pt)

Type	Indicateurs	Outils
Processus	Nombre de passages, d'exploitations, de saisonniers rencontrés, de kits remis, de langues utilisées ; respect du budget	Cahier de bord du camion, liste anonyme, tableau de bord
Résultats	Part des saisonniers qui sautent des repas ; part qui boit une boisson énergisante chaque jour ; satisfaction	Même questionnaire en fin de saison, comparaison avant / après
Impact (à moyen terme)	Nombre de malaises signalés au service de santé au travail, comparé à la saison précédente	Données agrégées et anonymes du service de santé au travail

Valorisation : bilan présenté au conseil d'administration de la MSA et aux employeurs ; article dans la lettre des producteurs ; fiche « retour d'expérience » pour les autres caisses de MSA ; intégration de l'action au contrat local de santé ; ajustements pour la saison suivante (plus de kits, horaires du camion adaptés à la chaleur).

Partie B – Recherche appliquée

Question 7 – Risque relatif (1,5 pt)

Calcul posé – Risque relatif de sauter des repas selon le logement

- Exposés (sans moyen de cuisson) : 47 / 74 = 0,635, soit **63,5 %**.
- Non exposés (avec moyen de cuisson) : 34 / 112 = 0,304, soit **30,4 %**.
- Risque relatif RR = 0,635 / 0,304 = **2,09**.

Vérification des effectifs : 47 + 34 = 81 saisonniers qui sautent des repas, comme dans le tableau.

Interprétation : les saisonniers sans moyen de cuisson ont environ **deux fois plus de risque** de sauter des repas que les autres. On ne peut pas conclure à une **causalité** : c'est une enquête transversale (exposition et comportement mesurés en même temps), sur un échantillon non représentatif ; des **facteurs de confusion** peuvent expliquer l'association (revenu plus faible, isolement, âge, horaires) ; il faudrait vérifier la significativité (intervalle de confiance du RR) et ajuster sur ces facteurs.

Question 8 – Intervalle de confiance, taille d'échantillon, biais (1,5 pt)

Calcul posé – Intervalle de confiance à 95 % et taille d'échantillon

p = 81 / 186 = 0,435 ; n = 186.

Erreur type = racine de (0,435 × 0,565 / 186) = racine de 0,001321 = 0,0364.

Marge = 1,96 × 0,0364 = 0,071, soit 7,1 points.

IC 95 % = [43,5 – 7,1 ; 43,5 + 7,1] = **[36,4 % ; 50,7 %]**.

Taille pour ± 5 points : n = 1,96 × 1,96 × 0,435 × 0,565 / (0,05 × 0,05) = 377,8, soit **378** saisonniers.

Correction pour une population finie de N = 2 400 : n' = n / (1 + (n – 1) / N) = 377,8 / (1 + 376,8 / 2 400) = 377,8 / 1,157 = **327** saisonniers.

Biais : **biais de sélection** (seules 11 exploitations visitées, choisies par les infirmières ; saisonniers présents à la pause) ; **biais de non-réponse** (7,75 % de participation ; les plus fatigués ou les moins à l'aise avec l'écrit ont pu refuser) ; **biais de déclaration et de désirabilité sociale** (questionnaire proposé par des soignants de la MSA, liés à l'employeur dans l'esprit des saisonniers) ; **biais de traduction** (sens des questions selon la langue).

Partie C – Veille

Question 9 – Organiser une veille (2 pts)

- **Besoins** : recommandations sur la chaleur et le travail ; hydratation et alimentation à l'effort ; santé des travailleurs saisonniers et détachés ; outils en langues étrangères.
- **Sources fiables** : ministère du Travail (recommandations « canicule » de chaque été) ; Santé publique France (alertes canicule, outils de prévention traduits) ; INRS (dossiers sur le travail à la chaleur) ; MSA (prévention santé-sécurité au travail en agriculture) ; ANSES (avis sur les boissons énergisantes, 2013) ; HCSP ; Météo-France (vigilance canicule) ; bases bibliographiques (PubMed, Cairn) pour les études sur les travailleurs agricoles.
- **Outils** : alertes par courriel et flux RSS des sites officiels ; agrégateur de flux ; tableau de veille partagé (date, source, résumé, utilité, action).
- **Fréquence** : hebdomadaire de mai à octobre ; quotidienne pendant les épisodes de vigilance canicule.
- **Diffusion** : note d'une page aux infirmières et à la responsable prévention chaque semaine ; affichage dans le camion ; message aux employeurs en cas de vigilance orange ou rouge.
- **Évaluation** : nombre d'informations utilisées dans le projet ; retour des destinataires.

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique

Question 10 – Les deux demandes du document 5 (1,5 pt)

- **Les canettes offertes** : refus. Le partenariat créerait un **conflit d'intérêts** et contredirait l'objectif spécifique 2 ; l'ANSES (2013) met en garde contre la consommation de boissons énergisantes à l'effort et à la chaleur ; le logo d'une marque sur les supports d'un programme de prévention nuirait à sa crédibilité (et à l'**e-réputation** de la MSA si les affiches circulent sur les réseaux).
- **La liste des saisonniers ayant fait un malaise** : refus. Ce sont des **données de santé**, couvertes par le **secret professionnel** des infirmières et le **secret médical** ; le RGPD les classe parmi les données sensibles ; leur transmission à l'employeur exposerait les salariés à une **discrimination à l'embauche**, interdite par le code du travail. Seul le médecin du travail se prononce sur l'aptitude, sans donner de diagnostic à l'employeur.
- **Réponse de la MSA (exemple)** : « Nous vous remercions de votre proposition. Notre programme de prévention ne peut pas accepter de partenariat avec des marques dont les produits font l'objet de mises en garde sanitaires. » ; « Les informations de santé recueillies par nos infirmières sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent pas vous être transmises. Nous vous proposons en revanche de signer la charte "pause fraîcheur" et d'adapter les horaires de travail lors des fortes chaleurs. »

Question 11 – Communication, exposé et questions du jury (1,5 pt)

Supports adaptés : affiches et dépliants **en pictogrammes** et photos, avec des textes très courts traduits en quatre langues et relus par des locuteurs ; démonstration et dégustation plutôt que discours ; vidéo de 30 secondes sans parole diffusée sur l'écran du camion ; message vocal enregistré par l'interprète ; pas d'application à télécharger (précarité numérique, forfaits limités).

> **Préparer l'oral – Trame de l'exposé de 10 minutes**
>
> 0 – 1 min : contexte et demande. 1 – 3 min : diagnostic (déterminants, RSM, enquête, besoins). 3 – 4 min : problème central et objectifs. 4 – 6 min : plan d'action, partenaires, budget, universalisme proportionné. 6 – 7 min : communication en quatre langues. 7 – 8 min 30 : évaluation et premiers résultats. 8 min 30 – 9 min 30 : éthique (canettes, liste de l'employeur). 9 min 30 – 10 min : bilan personnel et ajustements.

> **Questions probables du jury – Questions probables et réponses attendues**
>
> 1. Pourquoi avoir utilisé un RSM et pas seulement le taux brut ? Parce que la structure d'âge du canton diffère de celle du département.
> 2. Votre RSM concerne-t-il les saisonniers ? Non, les résidents du canton ; c'est un signal de contexte.
> 3. Qu'est-ce que le modèle de Dahlgren et Whitehead ? Un modèle en arc-en-ciel à cinq niveaux de

déterminants, de l'individu aux conditions socio-économiques.

4. Pourquoi parler d'inégalité sociale de santé ? Écart systématique, évitable et injuste, lié à la position sociale.
5. Votre RR prouve-t-il que l'absence de cuisine fait sauter des repas ? Non : association, enquête transversale, facteurs de confusion.
6. Comment avez-vous calculé la taille d'échantillon ? Formule de la proportion et correction pour population finie.
7. Pourquoi ne pas avoir fait de pesée ? Ce n'est pas l'objectif ; risque de stigmatisation ; données de santé.
8. Qu'est-ce que l'universalisme proportionné ? Une action pour tous, d'intensité proportionnée au besoin (Marmot, 2010).
9. Pourquoi refuser les canettes gratuites ? Conflit d'intérêts, avis de l'ANSES, crédibilité.
10. Que dit le RGPD sur les données de santé ? Ce sont des données sensibles, traitées seulement avec une base légale, minimisées et sécurisées.
11. Comment avez-vous travaillé avec les employeurs ? Charte, syndicat des producteurs, intérêt commun (moins d'accidents).
12. Quelles collations proposez-vous sans réfrigérateur ? Pain, fruits entiers, fruits secs et oléagineux, conserves de légumineuses ou de poisson, fromages à pâte pressée cuite pour une demi-journée avec pain de glace.
13. Quels sont les besoins en eau à la chaleur ? Boire régulièrement, avant d'avoir soif, par petites quantités, selon les recommandations du ministère du Travail et de Santé publique France.
14. Comment évaluez-vous l'impact sur les malaises ? Données agrégées du service de santé au travail, comparaison avec la saison précédente, prudence (météo différente).
15. Quelles limites voyez-vous à votre projet ? Couverture partielle des kits, saisonniers mobiles, durée courte de la saison.
16. Comment le projet peut-il durer ? Inscription au CLS, charte des employeurs, kits financés par les exploitations.

Grille d'évaluation et barème

Partie	Indicateurs du référentiel évalués	Points
A – Projet	Analyse et diagnostic de situation posé (déterminants, indicateurs standardisés, besoins) ; objectifs formulés et adaptés ; plan d'action et moyens réalistes ; évaluation et valorisation (C3.1)	9
B – Recherche	Traitement et analyse des données (RR, IC, taille d'échantillon) ; biais ; prudence sur la causalité (C3.3)	3
C – Veille	Besoins identifiés ; sources fiables ; outils et diffusion (C3.4)	2
D – Communication et numérique	Supports adaptés à un public allophone ; e-réputation ; confidentialité des données de santé (C3.5, C3.6)	3
Expression	Expression écrite et orale maîtrisée ; vocabulaire ; sources datées	3
Total		20

Niveaux de maîtrise pour chaque partie : non maîtrisé (moins de 25 % des points), insuffisamment maîtrisé (25 à 49 %), maîtrisé (50 à 79 %), bien maîtrisé (80 % et plus).

Corrigé S2 – « Cuisiner sans cuisine » : un atelier pour des familles hébergées à l'hôtel

que le jury attend

Le jury attend un atelier pensé à partir des conditions de vie réelles des familles : pas de cuisine, pas de réfrigérateur, un petit budget, plusieurs langues, des femmes enceintes. Il évalue la justesse des calculs (quantités brutes, coût, apports Ciqual), la sécurité sanitaire (grossesse, allergie, conservation) et la capacité à rendre les familles autonomes avec une bouilloire et un four à micro-ondes. Il pénalise les recettes impossibles à refaire à l'hôtel et tout discours culpabilisant.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Besoins et objectifs (2 pts)

Besoins : **normatifs** (insécurité alimentaire très fréquente chez les familles sans logement : près de huit sur dix dans l'enquête ENFAMS de 2014 ; besoins accrus en fer et en folates pendant la grossesse) ; **ressentis** (fatigue des mères, sentiment de ne pas pouvoir « bien nourrir » ses enfants) ; **exprimés** (demande d'idées de repas sans cuisine) ; **comparatifs** (les familles logées disposent d'une cuisine, pas les familles hébergées à l'hôtel).

- **Objectif général** : permettre aux parents hébergés à l'hôtel de préparer des repas équilibrés, économiques et sûrs avec une bouilloire et un four à micro-ondes.
- **Objectifs opérationnels** : à la fin de l'atelier, chaque participant aura réalisé au moins une étape du dahl et de la compote (observation) ; aura goûté le repas complet et donné son avis sur la grille en pictogrammes (grilles remplies) ; sera reparti avec la fiche « version hôtel » illustrée et la liste de courses en pictogrammes (fiches remises) ; saura citer ou montrer deux règles de conservation sans réfrigérateur (questionnement oral avec l'interprète).

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 10 portions

Quantité nette totale = grammage net × 10 ; quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte) ; coût = quantité brute en kg × prix au kg.

Denrée	Quantité nette	Quantité brute	Unité de commande	Prix unitaire	Coût
Lentilles corail sèches	500 g	500 / 1 = 500 g	0,500 kg	3,20 € le kg	1,60 €
Carottes	600 g	600 / 0,85 = 705,9 g	0,706 kg	1,40 € le kg	0,99 €
Oignons	200 g	200 / 0,90 = 222,2 g	0,222 kg	1,80 € le kg	0,40 €
Tomates pelées au jus	800 g	800 g	0,800 kg	2,20 € le kg	1,76 €
Graine de couscous précuite	600 g	600 g	0,600 kg	1,90 € le kg	1,14 €
Pommes	1 000 g	1 000 / 0,80 = 1 250 g	1,250 kg	2,40 € le kg	3,00 €
Huile de colza	50 g	50 / 920 = 0,054 L	0,054 L	3,20 € le litre	0,17 €
Yaourts nature	10 pots	10 pots	10 pots	0,20 € le pot	2,00 €
Épices, ail, citron	–	–	forfait	–	0,80 €
Total					11,86 €

Coût par portion = 11,86 / 10 = **1,19 €**, inférieur au plafond de 1,50 € : le budget est respecté, avec une marge de 0,31 € par portion (on peut ajouter un fruit à emporter pour le goûter des enfants).

Question 3 – Fiche technique, version hôtel et adaptation sans lait (3 pts)

Modèle – Fiche technique du dahl de lentilles corail (10 portions)

Ingrédients : lentilles corail 500 g ; carottes 600 g nettes ; oignons 200 g nets ; tomates pelées au jus 800 g ; huile de colza 30 g ; ail 2 gousses ; curcuma, cumin, gingembre ; jus d'un demi-citron ; eau environ 1,2 L ; graine de couscous 600 g et 600 à 700 mL d'eau bouillante avec 20 g d'huile.

Matériel : faitout, planche et couteau (code couleur légumes), râpe, verre doseur, balance, fouet, cuillère en bois, saladier pour la semoule, thermomètre-sonde.

1. Laver les mains ; laver, éplucher et râper les carottes ; ciseler les oignons ; rincer les lentilles à l'eau froide.
2. Faire revenir oignons et épices 2 minutes dans l'huile, sans coloration forte.
3. Ajouter carottes, lentilles, tomates et eau ; porter à ébullition ; cuire 15 à 20 minutes à feu doux, en remuant, jusqu'à ce que les lentilles se défassent.
4. Ajouter le citron ; goûter ; saler peu.
5. Verser l'eau bouillante sur la graine de couscous et l'huile ; couvrir 5 minutes ; égrener à la fourchette.
6. Servir chaud (au moins 63 °C) dans les 30 minutes.

Points critiques : lavage des légumes (grossesse : toxoplasmose) ; cuisson complète des lentilles ; maintien au chaud ; pas de reste conservé à température ambiante.

Version hôtel (une portion, bol en verre ou en céramique allant au micro-ondes) : mettre 50 g de lentilles corail rincées, une carotte râpée finement, 80 g de tomates en boîte, une pincée d'épices et 150 mL d'eau ; couvrir sans fermer hermétiquement ; cuire 10 à 12 minutes à pleine puissance en remuant toutes les 4 minutes ; laisser reposer 2 minutes. Semoule : 60 g de graine de couscous et 60 à 70 mL d'eau de la bouilloire, couvrir 5 minutes. Compote : une pomme en petits dés et une cuillère à soupe d'eau, 3 à 4 minutes au micro-ondes, couvert. Matériel à fournir : un bol, une assiette pour couvrir, une cuillère doseuse, une fourchette. Courses en pictogrammes : produits secs et conserves qui se gardent sans froid (lentilles, semoule, tomates en boîte, fruits entiers).

Adaptation sans lait de vache : remplacer le yaourt par un dessert au soja nature enrichi en calcium (en vérifiant sur l'étiquette l'absence de lait et de protéines de lait, et en sachant que le soja est lui-même un allergène à déclarer) ; ustensiles et plan de travail propres pour éviter le contact croisé.

Question 4 – Apports nutritionnels (2 pts)

Calcul posé – Apport d'une portion (table Ciqual 2025, document 4)

Apport = quantité (g) × teneur pour 100 g / 100.

Aliment	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Fer (mg)	Calcium (mg)
Lentilles corail sèches	50 g	164,0	13,85	22,45	0,40	7,70	3,15	14,5
Carotte	60 g	18,1	0,47	3,10	0	1,74	0	21,7
Oignon	20 g	7,8	0,22	1,25	0,12	0,34	0	5,0
Tomates au jus	80 g	17,4	0,63	2,52	0,20	1,52	0,46	26,4
Huile de colza	5 g	45,0	0	0	5,00	0	0	0
Graine de couscous	60 g	219,6	7,38	43,62	0,79	2,70	0,65	14,4
Total du plat		472	22,6	72,9	6,5	14,0	4,3	82
Pomme cuite	100 g	54,0	0,26	11,20	0,36	2,40	0,19	5,0
Yaourt nature	125 g	62,6	4,79	5,33	2,10	0	0	171,3
Total du repas		589	27,6	89,5	9,0	16,4	4,5	258

Exemple de ligne : lentilles = 50 × 328 / 100 = 164,0 kcal ; 50 × 6,3 / 100 = 3,15 mg de fer.

Couverture pour une femme adulte : fer 4,45 / 11 × 100 = **40,5 %** ; fibres 16,4 / 30 × 100 = **54,7 %** ; calcium 258 / 950 × 100 = **27,2 %** (référence ANSES 2021 de 950 mg par jour à partir de 25 ans).

Part de l'énergie apportée par les lipides = 9,0 × 9 / 589 × 100 = **13,7 %**.

Interprétation : le repas est rassasiant, riche en fibres (plus de la moitié du repère journalier), correct en protéines grâce à l'association légumineuse + céréale, et il apporte 40,5 % du besoin journalier en fer d'une femme adulte. Le fer des lentilles est du fer non héminique, moins bien absorbé : la tomate et le citron (vitamine C) améliorent son absorption ; le thé ou le café sont à éloigner du repas. Il est pauvre en lipides (13,7 % de l'énergie) : on peut ajouter une cuillère d'huile de colza ou une poignée de graines (oméga 3, énergie) pour les mères qui allaitent ou qui manquent d'énergie. Pour les **femmes enceintes**, les besoins en fer et en folates augmentent : le repas y contribue (les lentilles sont riches en folates), mais il ne remplace pas le suivi par la sage-femme ou le médecin, qui peut prescrire une supplémentation ; le calcium est à compléter par un deuxième produit laitier dans la journée.

Question 5 – Déterminants et limites (2 pts)

L'atelier agit sur des **déterminants individuels** (connaissances, compétences culinaires, confiance en soi), sur les **réseaux sociaux** (repas partagé, entraide entre familles, rupture de l'isolement) et un peu sur l'**accès** (recettes à partir de produits qui se gardent sans froid, liste de courses à petit prix). Il ne change pas les **déterminants structurels** : absence de logement et de cuisine, revenus, interdiction de cuisiner dans les chambres, éloignement des commerces. Pour réduire réellement les inégalités, il faut l'associer à un **plaidoyer** et à des actions sur l'environnement : accès à une cuisine collective en libre-service à l'accueil de jour, chèques alimentaires ou paniers de produits frais, partenariat avec une épicerie solidaire, accès au réfrigérateur de l'accueil de jour, orientation vers le logement. Sinon, on risque de faire reposer sur les familles la responsabilité d'une situation qu'elles subissent.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire	Candidat	Participants
9 h 15 – 9 h 45	Réception et contrôle des denrées (dates, état des boîtes) ; rangement ; mise en place des 4 postes ; affichage des recettes en pictogrammes	–
9 h 45 – 10 h 00	Préparation de la démonstration micro-ondes ; coin enfants (jeux, coloriages) avec une bénévole	–
10 h 00 – 10 h 15	Accueil, présentation avec l'interprète, lavage des mains, tour de table « un plat de chez moi »	Lavage des mains, tablier
10 h 15 – 10 h 50	Guidage des binômes ; démonstration du dahl en faitout	Binôme 1 : légumes ; binôme 2 : lentilles et cuisson ; binôme 3 : semoule ; binôme 4 : pommes
10 h 50 – 11 h 10	Démonstration de la version hôtel au micro-ondes, réalisée par deux participantes	Réalisation, chronométrage, questions
11 h 10 – 11 h 40	Repas partagé et dégustation guidée	Dégustation, grille en pictogrammes
11 h 40 – 12 h 00	Échange « comment je fais à l'hôtel », remise des fiches et des kits (bol, couvercle), évaluation	Évaluation
12 h 00 – 12 h 15	Remise en état, plonge, tri des déchets, bilan écrit	–

Question 7 – Animation, outils et grille de dégustation (1,5 pt)

Méthodes : démonstrative (gestes de base, minutage du micro-ondes), active (les parents cuisinent), interrogative (partir des recettes de chacun : dahl, chorba, misir wot éthiopien ou érythréen à base de lentilles), valorisation des savoirs culinaires des familles. Outils : fiches recettes **en photos et pictogrammes** (bol, cuillère,

minuteur, nombre de minutes), liste de courses illustrée, vidéo courte sans parole à regarder sur téléphone, interprète bénévole. Posture : pas de jugement sur les achats actuels, phrases courtes, reformulation, vérification de la compréhension par le geste.

Critère	Pictogramme 1 (visage triste)	2 (visage neutre)	3 (visage souriant)
Aspect (dessin d'un œil)			
Goût (dessin d'une bouche)			
Épices (dessin d'un piment)			
Je vais le refaire (dessin d'une maison)			

Question 8 – Hygiène, conservation, allergènes, éco-gestes (1,5 pt)

Méthode des 5 M : **main-d'œuvre** (lavage des mains à l'arrivée et après les épluchures, cheveux attachés, personne malade écartée de la préparation) ; **matériel** (planches propres, bols adaptés au micro-ondes, thermomètre) ; **matières premières** (contrôle des boîtes : ni bombées ni rouillées, dates ; légumes lavés soigneusement, important pour les femmes enceintes) ; **milieu** (plans de travail désinfectés, enfants hors de la zone de cuisson) ; **méthode** (cuisson complète, service immédiat, pas de reste gardé).

À l'hôtel sans réfrigérateur : préparer **juste la quantité d'un repas** ; manger tout de suite ; ne pas garder un plat cuit plus de 2 heures à température ambiante ; acheter le yaourt le jour même ou le remplacer par un fruit ; préférer les produits qui se gardent sans froid (secs, conserves, fruits entiers) ; ouvrir une boîte de conserve juste avant usage. Au micro-ondes : remuer en cours de cuisson pour éviter les zones froides et les points brûlants ; attention aux brûlures (bol chaud, vapeur) et aux enfants.

Allergènes présents (règlement INCO n° 1169/2011) : **gluten** (graine de couscous), **lait** (yaourt) ; vérifier la présence éventuelle de **céleri** ou de **moutarde** dans les mélanges d'épices. Le dahl est naturellement sans porc et sans viande, ce qui convient aux familles qui ne mangent pas de porc.

Éco-gestes : épluchures compostées si l'accueil de jour a un composteur ; produits en vrac (lentilles, semoule) ; boîtes de conserve triées ; vaisselle réutilisable ; eau de la bouilloire chauffée à la juste quantité.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (3 pts)

Critères de réalisation : organisation du poste et marche en avant ; gestes techniques (épluchage, ciselage, cuisson à feu doux) ; texture du dahl (lentilles fondues, ni trop liquide ni sec) ; assaisonnement modéré en sel ; semoule bien égrenée ; compote réalisée au micro-ondes dans les temps ; deux assiettes dressées proprement, avec couleurs (persil ou coriandre) ; respect des températures ; propreté du poste en fin de séance.

Question 10 – Évaluation (1 pt)

Satisfaction : grille en pictogrammes (aspect, goût, épices, envie de refaire). Acquis : chaque participant montre une étape de la version hôtel ou une règle de conservation (observation, avec l'interprète). Intention : « Allez-vous refaire ce plat cette semaine ? » (main levée ou pictogramme). Suivi : question posée une semaine plus tard lors du passage à l'accueil de jour (« l'avez-vous refait ? »). Indicateur de processus : nombre de participants présents, de fiches et de kits remis, respect du budget (1,19 € par portion).

Barème – Barème du sujet

Besoins et objectifs 2 ; bon de commande 2 ; fiche technique, version hôtel et adaptation 3 ; calculs nutritionnels et interprétation 2 ; déterminants et limites 2 ; déroulé 2 ; animation et grille 1,5 ; hygiène, conservation, allergènes, éco-gestes 1,5 ; réalisation 3 ; évaluation 1 ; total 20.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Oublier que les familles n'ont pas de réfrigérateur ; proposer une recette impossible au micro-ondes ; oublier le gluten de la semoule ; calculer le coût sur les quantités nettes au lieu des quantités brutes ; affirmer que le

repas « couvre les besoins en fer » de la femme enceinte ; présenter l'atelier comme la solution aux inégalités.

Corrigé S3 – Vivre avec un trouble psychique et bien manger : un groupe d'entraide mutuelle

que le jury attend

Ce sujet teste la capacité à relier une **inégalité de santé majeure** (surmortalité des personnes vivant avec un trouble psychique) à des déterminants multiples, sans réduire la question au poids ni aux médicaments. Le jury attend le respect du fonctionnement d'un GEM (les adhérents décident), une grande prudence sur les données de santé, des séances courtes et concrètes, et des calculs exacts.

Temps 1

Question 1 – Indicateurs et comparaison (4 pts)

Calcul posé – Indicateurs de l'enquête (n = 36)

- Repas sauté au moins 4 jours sur 7 : 15 / 36 × 100 = **41,7 %**.
- Plat préparé ou restauration rapide au moins 4 fois par semaine : 19 / 36 × 100 = **52,8 %**.
- Au moins 1 litre de boisson sucrée par jour : 11 / 36 × 100 = **30,6 %**.
- Fruits ou légumes chaque jour : 10 / 36 × 100 = **27,8 %**.
- Tabagisme quotidien : 21 / 36 × 100 = **58,3 %**.
- Traitement perçu comme « faisant grossir » : 22 / 36 × 100 = **61,1 %**.
- Souhait de participer à un atelier : 27 / 36 × 100 = **75,0 %**.

Taux de réponse = 36 / 48 × 100 = **75,0 %**.

Prévalence de l'obésité mesurée au GEM = 12 / 30 × 100 = **40,0 %**.

Rapport avec la population générale = 40,0 / 17 = **2,35** : la prévalence est environ 2,4 fois plus élevée.

Limites de la comparaison : **petit effectif** (30 personnes mesurées : un seul cas de plus ou de moins change la prévalence de 3,3 points) ; **population différente** (adhérents d'un GEM, peut-être plus âgés que les 18-74 ans d'ESTEBAN ; pas de standardisation sur l'âge et le sexe) ; **dates différentes** (2014-2016 pour ESTEBAN) ; **biais de sélection** (les personnes qui acceptent la mesure ne sont pas forcément représentatives : six répondants ont refusé). La comparaison donne un ordre de grandeur cohérent avec la littérature, pas une mesure précise.

Question 2 – Déterminants et inégalité (3 pts)

Type de déterminant	Dans la situation
Individuels et biologiques	Effets indésirables de certains traitements antipsychotiques (augmentation de l'appétit, prise de poids, troubles métaboliques) ; fatigue le matin ; difficultés de concentration et de motivation liées à la maladie
Comportements	Repas sautés, plats préparés, boissons sucrées, tabagisme très fréquent (58,3 %), sédentarité
Liés au système de soins	Suivi somatique souvent insuffisant (attention centrée sur les troubles psychiques), dépistage moins fréquent des facteurs de risque cardiovasculaire
Sociaux et économiques	Faibles revenus (allocation aux adultes handicapés), isolement, logement parfois sans équipement, peur du regard des autres au supermarché, stigmatisation

C'est une **inégalité de santé** au sens fort : l'écart d'espérance de vie (environ 16 ans chez les hommes et 13 ans chez les femmes, Irdes 2018) est considérable, il est en grande partie **évitable** (causes cardiovasculaires et métaboliques accessibles à la prévention) et il résulte de conditions de vie, de la stigmatisation et d'un accès aux soins somatiques plus difficile, donc il est **injuste**.

Question 3 – Objectifs et plan d'action (5 pts)

- **Objectif général** : contribuer à améliorer l'alimentation et la santé cardiométabolique des adhérents du GEM « L'Escale » en développant leur autonomie pour cuisiner et faire leurs courses.
- **Objectif spécifique 1** : d'ici juin 2028, faire passer de 27,8 % à 45 % la part des adhérents répondants qui mangent des fruits ou des légumes chaque jour.
- **Objectif spécifique 2** : d'ici juin 2028, faire passer de 52,8 % à 35 % la part des adhérents qui mangent un plat préparé ou de la restauration rapide au moins 4 fois par semaine.
- **Objectifs opérationnels** : organiser 20 ateliers cuisine de 1 h 30 entre septembre 2027 et juin 2028, choisis avec les adhérents (feuille d'émargement) ; organiser 10 sorties accompagnées au marché ou au supermarché (nombre de sorties et de participants) ; réaliser avec les adhérents un livret de 20 recettes à moins de 2,50 € par portion avant juin 2028 ; organiser 6 séances de marche ou d'activité physique adaptée avec un intervenant (nombre de séances).

Plan d'action : septembre, présentation du projet en assemblée et vote des adhérents (autodétermination) ; constitution d'un comité de pilotage avec deux adhérents volontaires, l'animatrice et l'infirmière du CMP ; octobre à juin, ateliers tous les 15 jours en fin de matinée (pas tôt le matin à cause de la fatigue liée aux traitements), séances de 1 h 30 découpées en séquences de 15 à 20 minutes ; sorties courses en petit groupe ; marche hebdomadaire au printemps ; juin, évaluation et fête de présentation du livret. Partenaires : CMP (infirmière, médecin pour le suivi somatique), ARS (financement PTSM), épicerie solidaire, association d'activité physique adaptée, maison de santé (dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire, aide au sevrage tabagique).

Question 4 – Évaluation et budget (3 pts)

Type	Indicateurs	Outils
Processus	Nombre d'ateliers, de sorties, de participants par séance, de recettes du livret ; respect du budget ; part des décisions prises par les adhérents	Émargement, comptes rendus du comité, tableau de bord
Résultats	Part des adhérents qui mangent des fruits ou légumes chaque jour, qui consomment des plats préparés 4 fois par semaine ou plus ; satisfaction ; sentiment de compétence en cuisine	Même questionnaire lu à voix haute en juin ; échelle de confiance de 1 à 5
Impact (long terme, hors projet)	Évolution du suivi somatique (dépistages réalisés), qualité de vie	Données agrégées du CMP, avec accord

Calcul posé – Budget prévisionnel (prix construits pour le sujet)

- Denrées : 20 ateliers × 8 portions × 2,50 € = 400,00 €.
- Petit matériel (balance, minuteurs, boîtes, deux poêles) : 180,00 €.
- Tickets de bus pour les sorties : 10 sorties × 8 personnes × 1,60 € = 128,00 €.
- Impression du livret : 50 exemplaires × 3,20 € = 160,00 €.
- Intervenant en activité physique adaptée : 6 séances × 40,00 € = 240,00 €.
- Imprévus : 92,00 €.

Total : 400 + 180 + 128 + 160 + 240 + 92 = **1 200,00 €**.

Question 5 – Éthique, droit et communication (3 pts)

- Le poids, la taille, les traitements et le diagnostic psychiatrique sont des **données de santé**, sensibles au sens du RGPD : recueil seulement avec un **consentement écrit, libre et éclairé**, pour un objectif précis ; **minimisation** (on ne recueille pas le diagnostic) ; anonymisation pour l'analyse ; stockage sécurisé (dossier protégé par mot de passe, pas de clé USB non chiffrée) ; durée de conservation limitée ; droit de retrait à tout moment.

- **Secret professionnel** : l'infirmière du CMP ne transmet pas de données individuelles à l'animatrice ; seuls des résultats agrégés sont présentés.
- **Non-stigmatisation** : ne pas peser en public, ne pas afficher de résultats individuels, présenter l'atelier comme « cuisine et plaisir » et non comme un « atelier minceur » ; ne jamais faire du poids l'objectif de l'action.
- **Photos et réseaux sociaux** : autorisation écrite de droit à l'image pour chaque photo, avec possibilité de refuser sans conséquence ; pas de visage reconnaissable par défaut (mains, plats) ; aucune mention qui permettrait d'identifier une personne comme vivant avec un trouble psychique ; validation des publications par le comité des adhérents.

Question 6 – Expression et sources (2 pts) : vocabulaire précis (prévalence, rapport de prévalences, déterminants, autodétermination), sources datées (Irdes 2018, ESTEBAN 2017, loi du 11 février 2005, loi du 26 janvier 2016).

Temps 2

Question 7 – Besoins, objectifs et choix du menu (3 pts)

Besoins : manger plus de légumes et de fruits, réduire les plats préparés, cuisiner simple avec un petit budget, retrouver du plaisir et de la confiance, se sentir rassasié (appétit augmenté par certains traitements). Objectifs opérationnels : à la fin de l'atelier, chaque adhérent aura cassé et battu des œufs, découpé un légume et surveillé une cuisson ; aura goûté les quatre préparations ; saura citer le coût d'une portion ; repartira avec la fiche recette.

Justification du menu : **omelette** (technique facile, rapide, peu coûteuse, végétarienne, protéines de bonne qualité) ; **légumes de saison** intégrés au plat ; **pommes de terre au four** (féculent rassasiant, peu de matière grasse, cuisson sans surveillance) ; **pain complet** (fibres, satiété) ; **fromage blanc aux framboises** (produit laitier, fruit, dessert peu sucré). Le menu respecte les végétariens (œufs et produits laitiers acceptés), peut être refait seul avec une poêle et un four ou un four à micro-ondes, et coûte moins de 2,50 € par portion.

Question 8 – Bon de commande, fiche technique, apports (5 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 8 portions

Denrée	Quantité nette	Quantité brute	Unité de commande	Prix	Coût
Œufs	16 œufs	16 œufs	16 pièces	0,28 € pièce	4,48 €
Courgettes	800 g	800 / 0,95 = 842,1 g	0,842 kg	2,20 € le kg	1,85 €
Poivrons	400 g	400 / 0,80 = 500 g	0,500 kg	3,50 € le kg	1,75 €
Pommes de terre	1 600 g	1 600 / 0,80 = 2 000 g	2,000 kg	1,20 € le kg	2,40 €
Huile de colza	80 g	80 / 920 = 0,087 L	0,087 L	3,20 € le litre	0,28 €
Pain complet	320 g	320 g	0,320 kg	4,20 € le kg	1,34 €
Fromage blanc 3 % MG	800 g	800 g	0,800 kg	2,60 € le kg	2,08 €
Framboises surgelées	640 g	640 g	0,640 kg	7,50 € le kg	4,80 €
Sel, poivre, herbes	–	–	forfait	–	0,60 €
Total					19,58 €

Coût par portion = 19,58 / 8 = **2,45 €** : le plafond de 2,50 € est respecté.

Modèle – Fiche technique de l'omelette aux courgettes et aux poivrons (8 portions, deux poêles de 4 portions)

Ingrédients : 16 œufs ; 800 g nets de courgettes ; 400 g nets de poivrons ; 40 g d'huile de colza ; sel, poivre, herbes.

Matériel : 2 poêles antiadhésives, 2 saladiers, fouets, planches et couteaux, spatules, thermomètre-sonde.

1. Laver les mains ; laver les légumes ; tailler courgettes et poivrons en petits dés.
2. Faire revenir les légumes 8 à 10 minutes dans la moitié de l'huile.
3. Casser les œufs un par un dans un bol avant de les verser dans le saladier ; se laver les mains après avoir manipulé les coquilles ; battre, assaisonner.
4. Verser les œufs sur les légumes ; cuire à feu moyen en ramenant les bords vers le centre, puis couvrir 3 à 4 minutes jusqu'à ce que l'omelette soit prise à cœur (pas de partie baveuse, température à cœur d'au moins 63 °C au service).
5. Servir aussitôt.

Pommes de terre : éplucher, couper en quartiers, mélanger avec 40 g d'huile et les herbes, cuire 35 à 40 minutes au four à 200 °C en les retournant à mi-cuisson.

Points critiques : œufs (contamination des coquilles, cuisson complète) ; brûlures (four, poêle) ; maintien en température.

Calcul posé – Apport du repas complet par portion (table Ciqual 2025, document 4)

Aliment	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Œufs	100 g	140,0	12,80	0,06	9,83	0	0,31
Courgette	100 g	16,7	1,21	1,75	0,32	1,00	0,02
Poivron	50 g	11,3	0,40	1,75	0,14	0,75	0,01
Huile de colza	10 g	90,0	0	0	10,00	0	0
Pommes de terre	200 g	160,0	4,04	32,40	0,18	4,40	0
Pain complet	40 g	93,6	3,46	16,48	0,68	2,92	0,47
Fromage blanc	100 g	75,7	7,28	3,86	3,23	0,02	0,09
Framboises	80 g	38,3	0,95	4,66	0,64	3,44	0
Total		626	30,2	61,0	25,0	12,5	0,90

Part de l'énergie apportée par les lipides = 25,0 × 9 / 626 × 100 = **36,0 %** ; par les protéines = 30,2 × 4 / 626 × 100 = **19,3 %**.

Interprétation : repas complet et rassasiant (626 kcal), riche en protéines et en fibres (12,5 g, grâce aux légumes, aux pommes de terre, au pain complet et aux framboises), peu salé (0,90 g). La part des lipides (36,0 %) se situe dans l'intervalle de référence de l'ANSES (35 à 40 % de l'énergie), avec une bonne qualité grâce à l'huile de colza (oméga 3).

Question 9 – Déroulé, animation et dégustation (4 pts)

Durée	Contenu	Méthode
10 min	Accueil, lavage des mains, présentation du menu choisi par les adhérents	Interrogative, photos des plats
15 min	Pommes de terre : épluchage, découpe, mise au four	Active, en binômes
15 min	Légumes de l'omelette : lavage, découpe	Active, démonstration du geste de la « griffe »
15 min	Pause de 5 minutes puis œufs : casser, battre ; cuisson de l'omelette	Démonstrative puis active
10 min	Dessert : fromage blanc et framboises décongelées	Active
10 min	Calcul ensemble du coût d'une portion	Interactive, calculatrice
15 min	Dressage et rangement du poste	Active

Durée	Contenu	Méthode
Repas	Dégustation guidée, échanges, grille de dégustation	Conviviale

Animation : séquences courtes (15 minutes au plus), une seule consigne à la fois, consignes affichées en photos, valorisation de chaque réussite, possibilité de faire une pause, aucune remarque sur le poids. Grille de dégustation : aspect, odeur, goût, texture, « je le referai chez moi » (échelle de 1 à 4 avec visages).

Question 10 – Hygiène et éco-gestes (4 pts)

Œufs : œufs dont la coquille est propre et intacte, conservés au réfrigérateur ; casser chaque œuf dans un bol séparé ; se laver les mains après avoir touché les coquilles ; cuisson complète (pas d'omelette baveuse pour un public collectif). Restes : refroidir rapidement (moins de 10 °C à cœur en moins de 2 heures), conserver entre 0 et 4 °C, consommer dans les 24 heures, réchauffer à au moins 63 °C à cœur une seule fois. Allergènes à déclarer : **œuf**, **lait** (fromage blanc), **gluten** (pain complet). Sécurité : couteaux, four, poêles chaudes ; vigilance si certains adhérents ont une somnolence liée aux traitements. Éco-gestes : légumes de saison, épluchures au compost, eau de lavage limitée, four rempli (pommes de terre et autre préparation), vaisselle réutilisable, restes emportés dans des boîtes.

Question 11 – Réalisation et évaluation (4 pts)

Réalisation : omelette prise à cœur, dorée, légumes tendres ; pommes de terre dorées et cuites ; dessert présenté en coupes ; respect du temps et de l'hygiène. Évaluation : grille de dégustation ; question « qu'avez-vous appris aujourd'hui ? » ; nombre d'adhérents qui ont réalisé une étape seuls ; intention de refaire la recette ; retour au comité de pilotage pour choisir le menu suivant.

Barème – Barème du sujet mixte

Temps 1 : indicateurs et comparaison 4 ; déterminants 3 ; objectifs et plan d'action 5 ; évaluation et budget 3 ; éthique et communication 3 ; expression et sources 2 ; total 20.

Temps 2 : besoins et menu 3 ; bon de commande, fiche technique et apports 5 ; organisation et animation 4 ; hygiène et éco-gestes 4 ; réalisation et évaluation 4 ; total 20.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Faire de la perte de poids l'objectif du projet ; décider à la place des adhérents ; transmettre des données individuelles ; comparer 40,0 % à 17 % sans parler des limites ; oublier les allergènes œuf et gluten ; servir une omelette baveuse à un groupe.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Ce que je sais faire	Sujet	Acquis	En cours	À retravailler
C3.1	Classer les déterminants de santé (Dahlgren et Whitehead) et montrer une inégalité sociale de santé	S1, S3			
C3.1	Calculer un taux brut, des décès attendus et un rapport standardisé de mortalité	S1			
C3.1	Calculer et interpréter les indicateurs d'un diagnostic ; classer les besoins (Bradshaw)	S1, S3			
C3.1	Formuler des objectifs avec indicateur, cible et échéance	S1, S3			
C3.1	Appliquer l'universalisme proportionné à un plan d'action et à un budget	S1			
C3.2	Établir un bon de commande avec quantités brutes et nettes	S2, S3			
C3.2	Adapter une recette aux conditions de vie (sans cuisine, sans réfrigérateur)	S2			
C3.2	Calculer un apport nutritionnel avec la table Ciqual 2025 et la part des besoins couverte	S2, S3			
C3.2	Organiser un atelier pour un public allophone ou ayant des difficultés de concentration	S2, S3			
C3.2	Appliquer l'hygiène (5 M, œufs, conservation, allergènes) et les éco-gestes	S2, S3			
C3.3	Calculer un risque relatif, un intervalle de confiance, une taille d'échantillon ; discuter la causalité	S1			
C3.3	Discuter les limites d'une comparaison de prévalences	S3			
C3.4	Organiser une veille et la diffuser	S1			
C3.5	Adapter la communication (langues, pictogrammes, littératie, précarité numérique)	S1, S2			
C3.6	Protéger les données de santé et l'image des personnes ; refuser un conflit d'intérêts	S1, S3			

Modèles officiels utilisés : structure des sujets U62 (2002-2014) et E5.B (2021-2024) pour le bon de commande, la fiche technique et l'organisation ; BTS blanc CNED E5B pour l'adaptation d'une recette et le calcul nutritionnel ; texte de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024) pour la répartition des compétences entre les deux temps.

DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE

CHAPITRE 3

Éléments de psychologie sociale

Mots-clés : Psychologie, Sociologie, Anthropologie de l'alimentation

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 3 · Éléments de psychologie sociale · version normale

1 COURS

Mise en page normale · 96 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 99

2 FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 7 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 100 à 106

3 CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 114 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 107 à 220

4 ANNALES E5

Mise en page normale · 32 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 221 à 252

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 · Cours **4**

3.1 Compétences mobilisées 7
3.2 Croisement référentiel × précisions × indications 7
3.3 Cours 9
3.4 Approfondissements 74
3.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 82
3.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 83
3.7 L'essentiel à retenir 86
3.8 Entraînement 87
3.9 Glossaire 97
3.10 Renvois bibliographiques par notion 98
3.12 Bibliographie numérotée 98

2 · Fiche de révision et fiches-outils **100**

Fiche de révision du chapitre 3 102
1. Les définitions à savoir 102
2. Les modèles à connaître 103
3. Les 9 CPS générales (Santé publique France, 2022) 103
4. Les pièges 103
5. Auto-test 103
6. Flashcards 104
Compléments du chapitre enrichi 104
Fiches-outils du chapitre 3 104
O3.1 – Recueil et analyse des représentations 105
O3.2 – Profil du public et adaptations 105
O3.3 – Grille « étapes du changement » 105
O3.4 – Planifier le développement des CPS 105
O3.5 – Règles du groupe et charte de bienveillance 106
O3.6 – Auto-observation de ma posture interculturelle 106

3 · Cahier d'exercices **107**

Cahier d'exercices – Chapitre 3 110
Partie 1 – Regards sur le mangeur, socialisation et identité 111
Partie 2 – Représentations, normes, valeurs et culture 125
Partie 3 – Influence sociale, attitudes et stigmatisation 138
Partie 4 – Compétences psychosociales, émotions, image du corps et estime de soi 153
Partie 5 – Les modèles du changement de comportement 166
Partie 6 – Communiquer, écouter, accompagner la motivation 180
Partie 7 – Animer un groupe, motiver, tenir compte des biais de décision 194
Partie 8 – Mesurer les attitudes et les représentations ; cas complet 206
Bilan : grille d'auto-évaluation 220

4 · Annales E5 ..... **221**

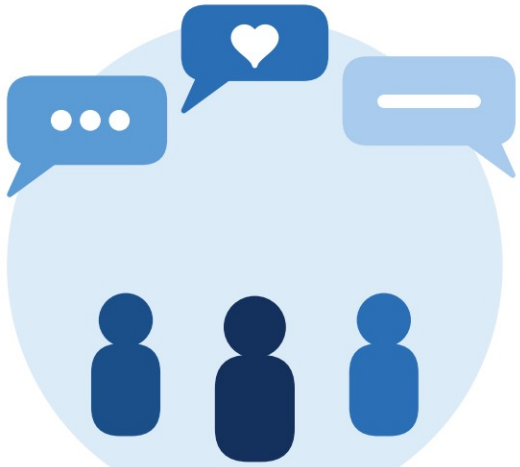
Cahier d'annales E5 – chapitre 3 223
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 224
Partie II – Les corrigés détaillés 234
Grille d'auto-évaluation 252

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS



CHAPITRE

03

Éléments de psychologie sociale

Psychologie | Sociologie | Anthropologie de l'alimentation

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

3.1 Compétences mobilisées 7

3.2 Croisement référentiel × précisions × indications 7

3.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 8

3.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 8

3.3 Cours 9

3.3.1 Psychologie, sociologie, anthropologie : trois regards sur le mangeur 10

3.3.2 Identité individuelle et sociale ; socialisation 13

3.3.3 Représentations, normes, valeurs ; culture et interculturalité 17

3.3.4 La relation sociale et ses dynamiques 23

3.3.5 Les compétences psychosociales 31

3.3.6 Image corporelle, émotions, estime de soi 34

3.3.7 Connaître les publics et comprendre le changement de comportement 37

3.3.8 Communiquer et écouter : les bases de la relation éducative 45

3.3.9 L'esprit de l'entretien motivationnel appliqué au collectif 48

3.3.10 Animer un groupe : étapes, rôles et styles d'animation 52

3.3.11 La motivation et les biais de décision 57

3.3.12 Mesurer attitudes et représentations 60

3.3.13 Un modèle intégrateur : COM-B et la roue du changement de comportement 64

3.3.14 Adapter l'approche psychosociale aux publics 68

3.3.15 Concevoir une séance qui développe les compétences psychosociales en nutrition 70

3.3.16 Fil rouge : les représentations et les dynamiques du groupe des Tilleuls 71

3.3.17 Trois cas guidés pour s'entraîner à l'analyse psychosociale 71

3.4 Approfondissements 74

3.4.1 Néophobie alimentaire et exposition répétée 74

3.4.2 Les normes sociales comme levier 75

3.4.3 L'influence des réseaux sociaux 76

3.4.4 La pair-éducation et les personnes relais 77

3.4.5 La motivation des enfants et des adolescents 78

3.4.6 Les émotions dans l'apprentissage 79

3.4.7 Précarité alimentaire : honte, dignité et pouvoir d'agir 80

3.4.8 Le numérique dans l'accompagnement du changement 80

3.4.9 Les personnes âgées : vieillissement, isolement et plaisir de manger 81

3.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 82

3.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 83

Méthode 1 – Justifier un choix d'animation par un modèle, à l'oral 84

Méthode 2 – Analyser une situation de groupe en quatre questions 84

Méthode 3 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve 84

3.7 L'essentiel à retenir 86

3.8 Entraînement 87

3.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 87

3.8.2 Exercices 88

3.8.3 Questions de réflexion 92

3.8.4 Étude de cas 92

3.8.5 Mises en situation express 93

3.8.6 Exercices complémentaires 95

3.9 Glossaire 97

3.10 Renvois bibliographiques par notion 98

3.12 Bibliographie numérotée..... 98

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- définir la psychologie, la sociologie et l'anthropologie et montrer ce que chacune apporte à la compréhension des comportements alimentaires ;
- définir l'identité individuelle et sociale, la socialisation primaire et secondaire, et les appliquer à l'alimentation ;
- définir les représentations sociales, les normes, les valeurs et les attitudes ;
- définir la culture, identifier des différences culturelles et expliquer l'interculturalité et l'acculturation (spontanée et planifiée) ;
- décrire les dynamiques d'une relation sociale et d'un groupe (influence, conformisme, engagement) ;
- définir les compétences psychosociales et proposer des activités pour les développer ;
- définir l'image corporelle, l'insatisfaction corporelle, les émotions, l'estime de soi et la confiance en soi, et en tenir compte dans une action ;
- connaître les spécificités des publics et les principaux modèles du changement de comportement ;
- relier ces savoirs à vos propres observations et interroger votre propre système de valeurs (objectif du guide 2025).

3.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.1	Comprendre les publics et les ressorts du changement pour concevoir des actions adaptées et non stigmatisantes	Priorités et objectifs adaptés au contexte ; règles éthiques respectées
C3.2	Adapter un atelier culinaire aux cultures, aux âges et aux émotions liées à l'alimentation	Besoins, objectifs et spécificités du public identifiés ; méthodes d'animation appropriées
C3.5	Animer un groupe, mobiliser l'écoute active, gérer les dynamiques et les émotions	Techniques d'animation et posture adaptées ; capacités d'écoute active mobilisées

3.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Psychologie, sociologie, anthropologie	Définir et distinguer ; citer des apports à l'alimentation	Connaître quelques auteurs repères (Fischler, Poulain, Lewin)
Identité individuelle et sociale	Définir ; exemples alimentaires	Pas de théorie de la personnalité
Compétences psychosociales	Définir, classer (cognitives, émotionnelles, sociales), proposer des activités	Référentiel Santé publique France 2022
Représentations, normes, valeurs	Définir, recueillir et utiliser les représentations d'un public	Méthodes de recueil (photolangage, associations libres)
Culture, interculturalité, acculturation	Identifier les différences culturelles ; adopter une posture interculturelle	Modèle de Berry ; acculturation spontanée et planifiée
Relation sociale, socialisation	Décrire les dynamiques ; rôle de la famille, de l'école, des pairs	Expérience de Lewin, conformisme, engagement
Image corporelle, émotions, estime de soi	Définir ; repérer les risques (stigmatisation, restriction)	Orientation si troubles du comportement alimentaire (BC1)

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Connaissance des publics	Adapter l'action à l'âge, la culture, la précarité, le handicap	Modèles du changement : HBM, Prochaska, Ajzen, Bandura

3.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : bloc 3, savoirs « Éléments de psychologie sociale ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 60 et 61). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les corrections sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 3.2.2.

Texte	Critère ou indication	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 60-61	Définitions : psychologie, sociologie, anthropologie	3.3.1 (trois regards, fondateurs à connaître)
Guide 2025, p. 61	Identité individuelle et sociale ; socialisation primaire et secondaire	3.3.2 (dont identité collective, déviance)
Guide 2025, p. 61	Représentations, normes, valeurs ; culture, interculturalité, acculturation spontanée et planifiée	3.3.3
Guide 2025, p. 61	Relation sociale et ses dynamiques	3.3.4 (influence, attitudes, stéréotypes, communication, rumeurs) ; 3.3.10
Guide 2025, p. 61	Compétences psychosociales et leur développement	3.3.5 et 3.3.15 (référentiel de Santé publique France, 2022)
Guide 2025, p. 61	Image corporelle, émotions, estime de soi	3.3.6
Guide 2025, p. 61	Connaissance des publics et de leurs spécificités	3.3.7 (dont pauvreté et exclusion) ; 3.3.14 (dont développement et maladie)
Référentiel, C3.1, C3.2, C3.5	Publics, objectifs adaptés, animation, écoute active	3.3.7 à 3.3.16 ; 3.6

3.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié par rapport au fascicule *Environnement professionnel – Synthèse du cours en bref*, 1re année (CNED 3-6123-AN-WT-00-21), module 5 « Éléments de psychologie et de sociologie » (p. 32 à 46). Les pratiques et comportements alimentaires (module 2) sont traités au chapitre 4.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
M5 S1 §1 et §2 (p. 32 et 33)	Sociologie et psychologie ; fondateurs : Marx, Durkheim, Weber, Freud, Winnicott, Piaget, Bowlby	3.3.1 (fondateurs à connaître)
M5 S1 §3 et §4 (p. 33)	Socialisation ; identités individuelle, collective et sociale	3.3.2
M5 S1 §5 et §6 (p. 34)	Déviance (Merton, Becker) et délinquance	3.3.2 (déviance et délinquance)
M5 S2 §1 (p. 35 et 36)	Représentations sociales (Moscovici, Jodelet, Abric) ; stéréotypes, TIP, préjugés, discriminations	3.3.3 ; 3.3.4 (stéréotypes, juger autrui)
M5 S2 §2 (p. 36 à 38)	Communication (modèle de Shannon, moi intime et moi public, non-verbal) ; attitudes, distances, analyse transactionnelle ; rumeurs	3.3.4 (communiquer) ; 3.3.8
M5 S2 §3 (p. 38 et 39)	Intégration, lien social, socialisation, pauvreté, exclusion ; disqualification (Paugam), désaffiliation (Castel) ; classes, stratification, Bourdieu	3.3.7 (vocabulaire de la sociologie)

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
M5 S3 (p. 40 à 43)	Courants de la psychologie du développement ; stade du miroir ; stades de Piaget ; adolescence, adulte, personne âgée	3.3.14 (développement de la personne)
M5 S4 (p. 44 à 46)	Maladie, psychosomatique, stress, mort ; rôle du diététicien	3.3.14 (maladie, stress et fin de vie)

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou était inexact

- **Durkheim** (p. 32) : le fascicule écrit qu'« il a mis en place la laïcité ». C'est faux : la laïcité de l'État vient de la **loi du 9 décembre 1905** (séparation des Églises et de l'État), votée par le Parlement. Durkheim est l'un des **fondateurs de la sociologie** (*Les Règles de la méthode sociologique*, 1895 ; *Le Suicide*, 1897) ; il a seulement défendu une morale laïque à l'école.
- **Définition de la psychologie** (p. 32) : la phrase « … agit sur son environnement social » définit la **psychologie sociale**. La psychologie étudie plus largement les processus mentaux et les comportements de la personne.
- **Pauvreté** (p. 39) : la pauvreté monétaire de l'Insee n'est pas « le seuil en deçà duquel il est impossible de survivre ». C'est une pauvreté **relative** (60 % du niveau de vie médian). Le seuil de **1 041 €** date de 2017 ; le dernier publié est de **1 337 € par mois en 2024** (Insee, 9 juillet 2026), avec un taux de pauvreté de **15,4 %** (9,8 millions de personnes).
- **« Définitions selon Durkheim »** (p. 38) : toutes ces notions ne sont pas de Durkheim. L'**exclusion sociale** a été popularisée par René Lenoir (1974), la **disqualification** par Serge Paugam (1991), la **désaffiliation** par Robert Castel (1995), et le seuil de pauvreté est une convention statistique.
- **Auteurs non nommés** : le fascicule ne cite pas les auteurs de la **proxémie** (Edward T. Hall, 1966), de l'**analyse transactionnelle** (Eric Berne), des mécanismes de la **rumeur** (Allport et Postman, 1947) ni des **trois phases du stress** (Hans Selye, 1936). Le cours les donne, car le jury attend des références.
- **Modèle de Shannon** (p. 37) : il s'agit du modèle de Shannon et Weaver (1949), conçu pour les télécommunications ; il oublie la rétroaction et le contexte, que complète le schéma de la section 3.3.8.

3.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Compétences psychosociales** : le référentiel de Santé publique France (2022) et la stratégie interministérielle de développement des compétences psychosociales des enfants et des jeunes (2022-2037) sont les textes de référence ; consultez les outils et retours d'expérience publiés depuis sur *santepubliquefrance.fr*.
- **Stigmatisation du poids** : le consensus international de 2020 (*Nature Medicine*) reste la référence ; vérifiez les recommandations françaises récentes sur la communication non stigmatisante (HAS, Santé publique France).
- **Pauvreté** : dernier seuil publié par l'Insee (9 juillet 2026) : 1 337 € par mois en 2024 ; taux de pauvreté 15,4 % (section 3.3.7).
- **PNNS 5 (2026-2030)** : lancé le 8 avril 2026, il compte 3 axes et 20 mesures ; son troisième axe vise à « faire des milieux de vie des espaces promoteurs de santé » (voir le chapitre 1).

3.3.1 Psychologie, sociologie, anthropologie : trois regards sur le mangeur

Module · Guide 2025 : p. 60-61 · CNED : Synthèse M5 S1 §1 et §2 (p. 32 et 33)

Discipline	Objet	Apport pour comprendre l'alimentation
Psychologie	Étude des processus mentaux et des comportements de l'individu (perceptions, émotions, motivations, apprentissages) ; la psychologie sociale étudie l'influence des autres sur l'individu	Préférences et aversions, néophobie, alimentation émotionnelle, motivation au changement, influence du groupe
Sociologie	Étude des groupes et des faits sociaux (classes sociales, institutions, normes)	Différences de pratiques selon le milieu social, le genre, l'âge ; repas comme fait social ; inégalités
Anthropologie	Étude de l'être humain dans ses dimensions culturelles (ethnologie) et biologiques, souvent par comparaison entre sociétés	Interdits, rites, symboliques des aliments, manières de table, cuisines du monde

Définition – Psychologie sociale

Discipline qui étudie la façon dont les pensées, les sentiments et les comportements des individus sont influencés par la présence réelle, imaginée ou implicite des autres (Gordon Allport, 1954). Elle se situe à l'interface de la psychologie (l'individu) et de la sociologie (le groupe).

Quelques repères en sociologie et anthropologie de l'alimentation

- **Claude Lévi-Strauss** (*Le cru et le cuit*, 1964) : la cuisine transforme la nature en culture ; le « triangle culinaire » (cru, cuit, pourri) montre que chaque société organise symboliquement ses aliments.
- **Claude Fischler** (*L'Homnivore*, 1990) : le **paradoxe de l'omnivore** : l'être humain a besoin de variété (**néophilie**), mais se méfie de l'inconnu (**néophobie**) ; le **principe d'incorporation** : « je deviens ce que je mange », d'où l'importance symbolique et l'anxiété autour des aliments. Il décrit aussi la **gastro-anomie** : l'affaiblissement des règles collectives du repas laisse le mangeur moderne seul face à des injonctions contradictoires.
- **Jean-Pierre Poulain** (*Sociologies de l'alimentation*, 2002) : l'**espace social alimentaire**, zone de liberté laissée au mangeur par les contraintes biologiques et environnementales, structurée en six dimensions.
- **Pierre Bourdieu** (*La Distinction*, 1979) : les goûts alimentaires sont socialement construits ; les milieux populaires valorisent le « nourrissant », les milieux favorisés la « légèreté » et la forme.

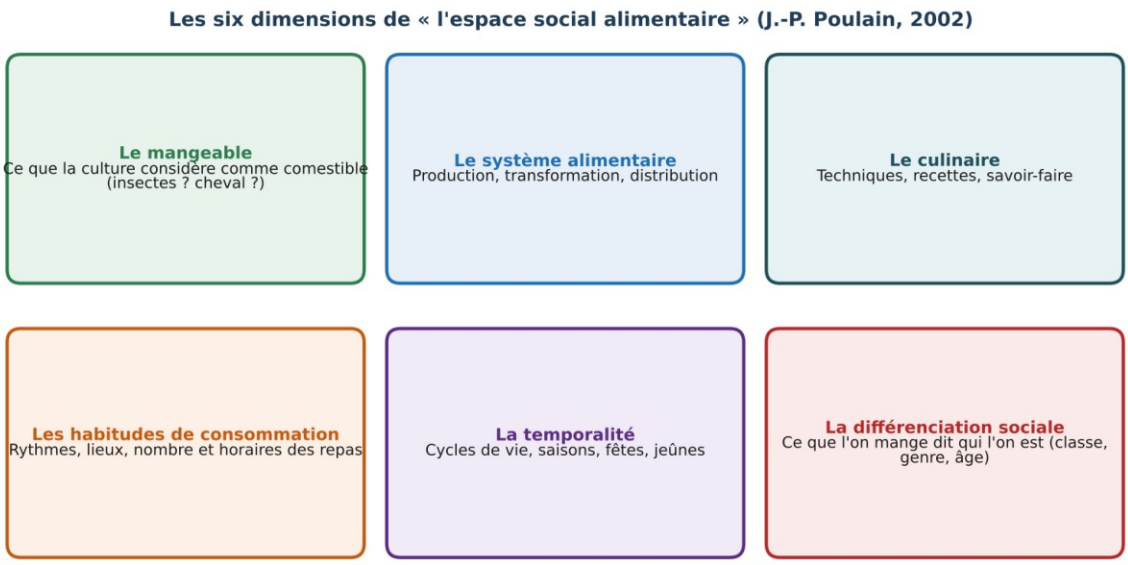


Figure 3.1 – Les six dimensions de l'espace social alimentaire (Poulain, 2002)

Comprendre le schéma – Figure 3.1

1. Le mangeable : chaque culture définit ce qui est comestible (le cheval, les insectes, le porc ne sont pas « mangeables » partout).

2. Le système alimentaire : chaîne de la production à la distribution, qui conditionne ce qui est disponible.

3. Le culinaire : techniques, recettes et savoir-faire qui transforment l'aliment.

4. Les habitudes de consommation : nombre de repas, horaires, lieux, prises hors repas.

5. La temporalité : âges de la vie, saisons, calendrier des fêtes et des jeûnes (Ramadan, Carême).

6. La différenciation sociale : l'alimentation marque l'appartenance à un groupe (classe, génération, genre, religion).

7. Lecture pour le diététicien : un conseil nutritionnel touche à **toutes** ces dimensions ; il est efficace s'il les respecte.

Les fondateurs à connaître (programme du CNED)

La **sociologie** donne des outils, un vocabulaire et des théories pour expliquer la vie sociale ; elle pose des questions et y répond par des hypothèses vérifiées sur le terrain. La **psychologie** étudie scientifiquement les processus mentaux et les comportements de la personne (perception, mémoire, émotions, jugement, action). Quand elle étudie l'influence des autres sur la personne, c'est la **psychologie sociale**.

Auteur	Discipline	Idée à retenir	Lien avec l'alimentation
Karl Marx (1818-1883)	Sociologie, économie	Classes sociales définies par la place dans la production ; domination et aliénation	Inégalités d'accès à une alimentation de qualité
Émile Durkheim (1858-1917)	Sociologie	Le fait social s'impose à l'individu ; intégration, lien social, solidarité mécanique (ressemblance) et organique (complémentarité)	Le repas partagé comme lien social ; l'isolement comme risque
Max Weber (1864-1920)	Sociologie	Comprendre le sens que les personnes donnent à leurs actions ; « type idéal » pour comparer ; stratification	Comprendre pourquoi une personne fait un choix alimentaire
Sigmund Freud (1856-1939)	Psychanalyse	Développement psycho-affectif ; place de l'inconscient et de l'enfance	Stade oral, valeur affective de la nourriture

Auteur	Discipline	Idée à retenir	Lien avec l'alimentation
Donald W. Winnicott (1896-1971)	Pédiatrie, psychanalyse	Lien entre le nourrisson et les soins maternels ; mère « suffisamment bonne »	Le nourrissage comme relation, pas seulement comme apport
Jean Piaget (1896-1980)	Psychologie du développement	L'intelligence se construit par adaptation, en quatre stades	Adapter les messages à l'âge des enfants
John Bowlby (1907-1990)	Pédopsychiatrie	Théorie de l'attachement : le lien au parent est un besoin premier	Climat affectif des repas de l'enfant

À vous de jouer – Exercice d'application 3.1

Associez chaque phrase à un auteur du tableau : a) « Le repas de famille entretient le sentiment d'appartenir au groupe. » b) « Un enfant de 5 ans ne comprend pas encore la notion abstraite de "nutriment". » c) « Pour comprendre ce choix, je cherche le sens que la personne lui donne. » d) « Un bébé a besoin de la présence stable d'une figure d'attachement pendant les repas. »

Corrigé

a) **Durkheim** (intégration, lien social). b) **Piaget** (stade préopératoire : pensée concrète, pas encore de raisonnement abstrait). c) **Weber** (sociologie compréhensive). d) **Bowlby** (attachement), et aussi Winnicott (soins maternels).

Les fonctions de l'alimentation : pourquoi mange-t-on ?

Manger ne sert pas seulement à couvrir des besoins en énergie et en nutriments. Les sciences humaines distinguent plusieurs **fonctions** de l'alimentation, toujours présentes en même temps. Un conseil qui n'en considère qu'une (la fonction nutritionnelle) a peu de chances d'être suivi.

Fonction	Ce qu'elle recouvre	Exemple	Conséquence pour l'action
Biologique (nutritionnelle)	Couvrir les besoins, apaiser la faim, se maintenir en santé	Manger des féculents avant un effort	Nécessaire mais rarement suffisante pour motiver
Hédonique (plaisir)	Goût, odeurs, textures, plaisir des sens	Le chocolat, le plat préféré	Garder le plaisir dans toute proposition
Psychologique et affective	Réconfort, régulation des émotions, souvenirs	Le gâteau de la grand-mère, manger quand on est triste	Comprendre l'alimentation émotionnelle sans juger
Sociale et relationnelle	Partager, recevoir, créer du lien, marquer les rythmes collectifs	Repas de famille, apéritif entre collègues	Proposer des repas partagés, agir avec le groupe
Identitaire	Dire qui l'on est et à quel groupe on appartient	Cuisine du pays d'origine, végétarisme, plats régionaux	Valoriser les cuisines d'origine, ne pas les dévaloriser
Symbolique et religieuse	Interdits, rites, fêtes, jeûnes	Ramadan, Carême, repas de Noël	Adapter le calendrier et le contenu des actions

Le modèle alimentaire français et la gastro-anomie

Le **modèle alimentaire français** (trois repas par jour à heures fixes, pris à table et à plusieurs) et son évolution sont présentés au chapitre 4. On retient ici une notion de sociologie utile pour comprendre le mangeur d'aujourd'hui.

Définition – Gastro-anomie (Fischler, 1979)

Situation du mangeur moderne qui, face à l'abondance de l'offre et à l'affaiblissement des règles collectives

(horaires, structure du repas, transmission familiale), doit faire seul ses choix au milieu de messages contradictoires (publicité, médecine, médias, réseaux sociaux). La gastro-anomie favorise l'anxiété alimentaire et la recherche de repères, parfois dans des régimes ou des modes peu fondés.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.2

Lors d'un atelier avec des retraités, une participante dit : « Depuis que je suis veuve, je ne fais plus de vrais repas : un yaourt et une tranche de jambon devant la télévision. Cuisiner pour une personne, ça ne vaut pas la peine. » a) Identifiez les fonctions de l'alimentation qui ont disparu pour elle. b) Expliquez pourquoi un conseil purement nutritionnel (« il faut manger des protéines et des légumes ») a peu de chances de réussir. c) Proposez deux actions qui redonnent leurs fonctions aux repas.

Corrigé

a) Les fonctions **sociale et relationnelle** (elle mange seule, sans personne pour qui cuisiner), **hédonique** (repas sans plaisir) et **identitaire** (son rôle de « celle qui cuisine pour la famille » a disparu). La fonction biologique elle-même est menacée (risque de dénutrition). **b)** Le conseil ne répond pas à la cause du problème, qui est la perte du sens social du repas ; il risque même de culpabiliser. **c)** Un repas partagé hebdomadaire au club ou au foyer-restaurant, où elle peut aussi transmettre une recette (valorisation, lien social) ; des recettes « pour un » rapides et des idées de portions à congeler, présentées lors d'un atelier convivial ; la participation à une action de « repas solidaires » entre voisins.

3.3.2 Identité individuelle et sociale ; socialisation

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M5 S1 §3 et §4 (p. 33) ; Synthèse M5 S1 §5 et §6 (p. 34)

Définition – Identité individuelle et identité sociale

- L'**identité individuelle** (ou personnelle) est l'ensemble des caractéristiques par lesquelles une personne se reconnaît comme unique (histoire, goûts, valeurs, image de soi).
- L'**identité sociale** est la partie de l'image de soi qui provient de l'**appartenance à des groupes** (famille, génération, origine, religion, profession, quartier) et de la valeur qu'on leur attribue (Tajfel et Turner, théorie de l'identité sociale, 1979).

L'alimentation est un puissant **marqueur d'identité** : « dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es » (Brillat-Savarin, 1825). Les plats familiaux, régionaux ou du pays d'origine, les interdits religieux (halal, casher, végétarisme hindou), les choix éthiques (végétarisme, véganisme) ou les styles de vie (« healthy ») expriment l'appartenance à un groupe. Toucher à l'alimentation, c'est toucher à l'identité : un conseil qui dévalorise un plat familial peut être vécu comme une attaque.

Définition – Socialisation

Processus par lequel une personne **intériorise** les normes, les valeurs et les pratiques de la société et des groupes auxquels elle appartient.

- **Socialisation primaire** : pendant l'enfance, principalement par la **famille** (goûts, horaires des repas, manières de table, aliments « de fête » et « de tous les jours »), puis l'école.
- **Socialisation secondaire** : à l'adolescence et à l'âge adulte, par l'école, les **pairs**, le travail, le couple, les médias et les réseaux sociaux ; elle peut renforcer ou transformer la socialisation primaire.

Exemple – La socialisation alimentaire en action

- Un enfant apprend à aimer les légumes s'il les goûte **à plusieurs reprises** (8 à 15 expositions sont souvent

nécessaires) dans un climat positif, en voyant ses parents en manger (modèle).
- À l'adolescence, les **pairs** et les réseaux sociaux prennent le relais : restauration rapide entre amis, boissons énergisantes, régimes vus sur les réseaux.
- À l'entrée dans la vie étudiante ou professionnelle, la cantine, les horaires et la vie en couple transforment les habitudes (socialisation secondaire).

Lien diététique – Ce que cela change pour l'animation

Pour un atelier avec des enfants, impliquer les **parents** (socialisation primaire) ; pour des adolescents, s'appuyer sur des **pairs** ou des ambassadeurs (socialisation secondaire) ; pour des adultes, partir des **plats familiaux** valorisés et proposer des adaptations plutôt que des ruptures.

Identité collective, déviance et délinquance

Le CNED distingue trois niveaux d'identité :

- l'**identité individuelle** : ce que la personne s'attribue (traits, rôles, valeurs) ;
- l'**identité collective** : la façon dont une personne se définit et est définie par les autres à partir de ses appartenances (profession, âge, genre, religion, territoire, famille) ;
- l'**identité sociale** : la combinaison des deux ; c'est ce qui permet aux autres de situer la personne, par la **catégorisation sociale**.

Définition – Déviance et délinquance

- La **déviance** est le fait de ne pas suivre une **norme sociale**, souvent implicite. Elle est relative : ce qui est déviant ici ou aujourd'hui peut être accepté ailleurs ou demain. Robert K. Merton (1938) l'explique par l'écart entre les buts valorisés et les moyens disponibles ; Howard Becker (*Outsiders*, 1963) montre qu'est déviant celui à qui le groupe **colle l'étiquette** de déviant.
- La **délinquance** est le non-respect d'une norme **écrite dans la loi** ; elle expose à une sanction pénale.

Lien diététique – Ne pas étiqueter les mangeurs

Manger seul, sauter un repas, refuser la viande ou suivre un jeûne religieux peuvent être vus comme « déviants » dans un groupe et normaux dans un autre. Le diététicien évite les étiquettes (« le mauvais élève », « l'obèse ») : selon Becker, l'étiquette elle-même peut enfermer la personne dans le comportement qu'on lui reproche.

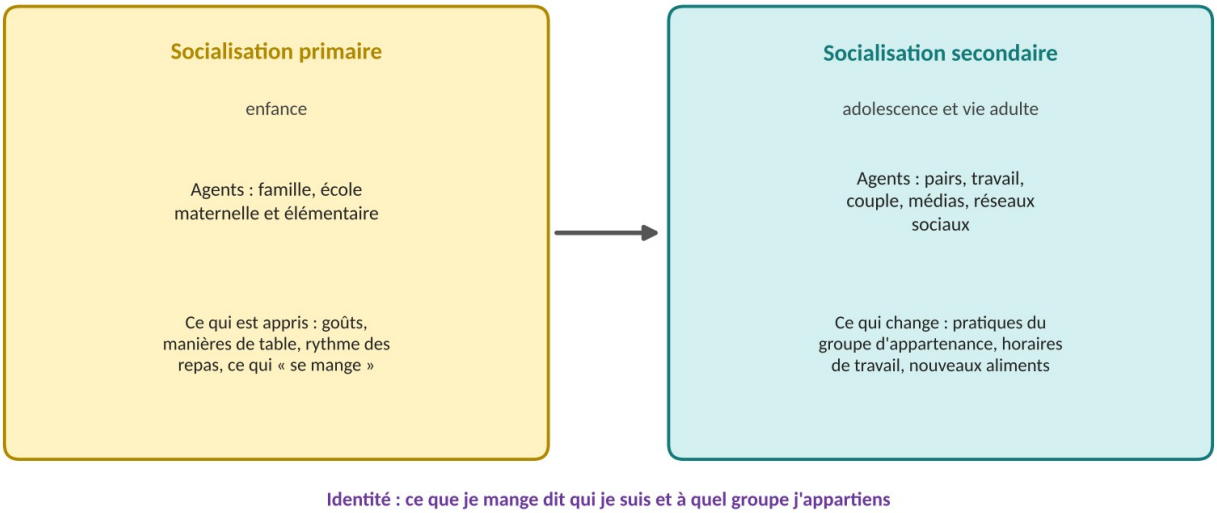


Figure 3.1 bis – Socialisation primaire et secondaire

Comprendre le schéma – Figure 3.1 bis

1. La **socialisation primaire** se fait dans l'enfance, surtout dans la famille et à l'école : l'enfant y apprend ses goûts, les manières de table, le rythme des repas et ce qui « se mange ».
2. La **socialisation secondaire** se poursuit toute la vie : pairs, travail, couple, médias et réseaux sociaux transforment ou renforcent les apprentissages de l'enfance.
3. La flèche montre une continuité : la socialisation secondaire ne remplace pas la primaire, elle s'y ajoute. Beaucoup d'adultes reviennent aux plats de leur enfance quand ils deviennent parents.
4. En bas, l'**identité** : ce que l'on mange dit qui l'on est et à quel groupe on appartient.

Identité sociale, groupes d'appartenance et de référence

Selon la théorie de l'identité sociale (Tajfel et Turner, 1979), chacun **catégorise** le monde en groupes, s'**identifie** à certains d'entre eux et se **compare** aux autres. On cherche une identité sociale positive : on valorise son groupe (**endogroupe**) par rapport aux autres (**exogroupes**). Le **groupe d'appartenance** est celui dont on fait partie ; le **groupe de référence** est celui auquel on se compare ou auquel on aimerait appartenir (un adolescent peut prendre pour référence un groupe de sportifs ou d'influenceurs).

Notion	Définition	Exemple alimentaire	Conséquence pour le diététicien
Catégorisation	Classer les personnes en groupes	« Les jeunes », « les bobos », « les gens du quartier »	Ne pas se présenter comme membre d'un groupe perçu comme « contre » le public
Favoritisme pour son groupe	Juger plus favorablement son propre groupe	« Chez nous, on mange bien, pas comme eux »	Valoriser les pratiques du groupe plutôt que celles d'un autre
Menace identitaire	Sentiment que l'identité de son groupe est dévalorisée	Un conseil qui critique un plat traditionnel	Partir des plats du groupe et proposer des adaptations
Groupe de référence	Groupe auquel on veut ressembler	Sportifs, influenceurs, collègues expérimentés	Faire porter le message par des modèles issus de ce groupe

Genre, normes et alimentation

Les pratiques alimentaires sont aussi marquées par les **normes de genre** apprises pendant la socialisation. Dans beaucoup de milieux, la viande rouge, les portions copieuses et la force sont associées au masculin, tandis que les légumes, les produits « légers » et le souci de la ligne sont associés au féminin. Ces normes expliquent en partie pourquoi, en moyenne, les hommes mangent plus de viande et moins de fruits et légumes que les femmes, et pourquoi les femmes sont davantage exposées aux régimes amaigrissants et à l'insatisfaction corporelle. Elles varient selon les milieux sociaux, les générations et les cultures, et elles évoluent.

Lien diététique – Utiliser l'identité plutôt que la combattre

- Avec un public masculin attaché à la « force », parler d'énergie, de récupération et de performance plutôt que de « régime ».
- Avec des personnes migrantes, partir des plats d'origine, souvent riches en légumineuses et en légumes, et les valoriser devant le groupe.
- Avec des adolescents, faire porter les messages par des pairs ou des modèles du groupe de référence.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.3

Dans un foyer de jeunes travailleurs, un résident de 19 ans dit : « Les légumes, c'est pour les filles. Moi je fais de la muscu, il me faut de la viande et des pâtes. » a) Identifiez la norme sociale et le groupe de référence en jeu. b) Expliquez pourquoi un message sur les « 5 fruits et légumes » risque d'être rejeté. c) Reformulez un message qui respecte son identité.

Corrigé

a) Une norme de genre qui associe les légumes au féminin et la viande à la force masculine ; le groupe de référence est celui des pratiquants de musculation. **b)** Le message entre en conflit avec son identité (menace identitaire) et avec les normes de son groupe de référence ; il sera perçu comme venant d'un exogroupe (« les diététiciens »). **c)** Exemple : « Les sportifs de haut niveau mettent des légumes dans chaque repas : ils apportent les vitamines et les minéraux qui aident les muscles à récupérer. Tu veux qu'on regarde ce que mange un athlète en préparation ? »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 3.3.1 et 3.3.2 – Regards sur le mangeur, identité et socialisation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Distinguez l'objet de la psychologie, de la sociologie et de l'anthropologie.
2. Énoncez le paradoxe de l'omnivore et donnez son auteur et son année.
3. Citez trois fonctions de l'alimentation, en plus de la fonction biologique.
4. Distinguez socialisation primaire et socialisation secondaire, avec un agent de chacune.
5. Qu'est-ce qu'un groupe de référence ? Donnez un exemple chez un adolescent.
6. Vrai ou faux : « La gastro-anomie désigne un trouble du comportement alimentaire. » Justifiez.

Corrigé – Point d'étape 3.3.1 et 3.3.2

1. La psychologie étudie l'individu (perceptions, émotions, motivations) ; la sociologie, les groupes et les faits sociaux (classes, genre, âge) ; l'anthropologie, les cultures (symboles, rites, interdits).
2. L'être humain a besoin de variété (néophilie) mais se méfie de l'inconnu (néophobie) ; Claude Fischler, *L'Homnivore*, 1990.
3. Par exemple : fonction sociale (partager, créer du lien), identitaire (dire qui l'on est), hédonique (plaisir), symbolique ou religieuse, éducative.
4. Primaire : pendant l'enfance, par la famille puis l'école. Secondaire : tout au long de la vie, par les pairs, le

travail, le couple, les médias.

5. Le groupe auquel on se compare ou auquel on aimerait appartenir, sans en faire forcément partie : des sportifs, des influenceurs.

6. Faux : c'est la perte de repères sur ce qu'il faut manger, quand les normes se multiplient et se contredisent (Fischler, 1979) ; ce n'est pas une maladie.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

3.3.3 Représentations, normes, valeurs ; culture et interculturalité

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M5 S2 §1 (p. 35 et 36)

Représentations sociales

Définition – Représentation sociale (Serge Moscovici, 1961)

Forme de connaissance **socialement élaborée et partagée**, qui permet aux membres d'un groupe d'interpréter la réalité et d'orienter leurs comportements (« sens commun »). Selon Jean-Claude Abric (1994), une représentation est organisée autour d'un **noyau central** stable (les éléments essentiels, difficiles à changer) et d'**éléments périphériques** plus flexibles.

Exemple – Représentations alimentaires fréquentes

« Un repas sans viande n'est pas un vrai repas » ; « manger équilibré coûte cher » ; « le pain fait grossir » ; « un enfant gros est un enfant en bonne santé » ; « bio = sans calories » ; « les féculents le soir font grossir ». Ces représentations ne sont pas des « erreurs » à corriger brutalement : elles ont une **cohérence** pour ceux qui les portent (expérience, culture, publicité). L'éducateur les **recueille** d'abord, puis les fait évoluer en s'appuyant sur les éléments périphériques (« un repas sans viande peut être complet s'il associe légumineuses et céréales »).

Méthode pas à pas – Recueillir les représentations d'un groupe

1. Associations libres : « Quand je dis "manger équilibré", à quoi pensez-vous ? » ; noter tous les mots au tableau, puis les regrouper.

2. Photolangage : choisir parmi 30 à 40 photos celle qui représente « bien manger pour moi » et expliquer son choix.

3. Abaque de Régnier : réagir à des affirmations avec des cartes de couleur (d'accord / pas d'accord) puis en débattre.

4. Classement de cartes : classer des aliments selon le prix, le plaisir, la santé, puis comparer.

5. Synthèse : repérer ce qui est partagé (noyau), ce qui varie, ce qui peut évoluer ; adapter les messages.

Comment se forme et à quoi sert une représentation sociale

Serge Moscovici (*La psychanalyse, son image et son public*, 1961) décrit deux processus qui transforment une notion nouvelle ou abstraite en savoir de sens commun.

- L'**objectivation** rend concret ce qui est abstrait : on sélectionne quelques éléments, on les simplifie et on en fait une image. « Manger équilibré » devient « manger de la salade et du poisson » ; « le cholestérol » devient « le gras qui bouche les artères ».
- L'**ancrage** rattache la nouveauté à des catégories déjà connues, ce qui la rend familière : « les produits ultra-transformés, c'est comme les plats tout prêts de la télé » ; « le bio, c'est comme les légumes du jardin de mon grand-père ».

Jean-Claude Abric (*Pratiques sociales et représentations*, 1994) attribue aux représentations **quatre fonctions**.

Fonction	Rôle	Exemple
De savoir	Comprendre et expliquer la réalité avec des mots communs	« Le sucre donne le diabète »
Identitaire	Situer la personne et son groupe, protéger leur image	« Nous, les ouvriers, on mange solide »
D'orientation	Guider les comportements, définir ce qui est attendu	« Un vrai repas, c'est un plat chaud » : on refuse la salade du soir
Justificatrice	Justifier après coup les choix et les comportements	« Je ne mange pas de légumes parce que c'est trop cher »

Noyau central et périphérie

	Noyau central	Éléments périphériques
Rôle	Donne le sens de la représentation, l'organise	Adaptent la représentation aux situations concrètes
Caractère	Stable, consensuel, lié à l'histoire et aux valeurs du groupe	Souples, variables selon les personnes
Face au changement	Résiste ; s'il change, la représentation change entièrement	Évoluent facilement ; ils protègent le noyau
Comment l'identifier	Fréquent et cité tôt dans l'évocation ; massivement refusé quand on le met en cause	Moins fréquent ou cité tard ; on accepte de s'en passer

Méthode pas à pas – Vérifier qu'un élément est central : le questionnaire de mise en cause (Moliner, 1988)

1. Partir des éléments situés dans la zone du noyau après une évocation hiérarchisée.

2. Pour chacun, poser la question : « Peut-on encore parler de [objet] si [élément] est absent ? » (par exemple : « Un repas peut-il être un vrai repas s'il n'y a pas de plat chaud ? »).

3. Calculer la part de réponses « non » : un élément refusé par une très large majorité (souvent au moins 75 %) est central ; un élément que beaucoup acceptent de retirer est périphérique.

4. En déduire les leviers : on agit d'abord sur la périphérie, en s'appuyant sur le noyau, sans le heurter.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.4

Dans un quartier, 100 parents répondent à un questionnaire de mise en cause sur « le petit-déjeuner ». « Peut-on parler de petit-déjeuner sans boisson chaude ? » : 82 répondent non. « … sans pain ni céréales ? » : 64 répondent non. « … s'il est pris debout ? » : 21 répondent non. a) Calculez les pourcentages et appliquez la règle des 75 %. b) Que proposez-vous aux familles qui manquent de temps le matin ?

Corrigé

a) Boisson chaude : 82 / 100 = **82 %** de « non » : élément central. Pain ou céréales : **64 %** : sous le seuil, élément plutôt périphérique mais important. Pris assis : **21 %** de « non » seulement : élément périphérique

(on accepte un petit-déjeuner pris debout). **b)** Ne pas toucher au noyau (garder une boisson chaude, par exemple un lait chaud ou un chocolat) et agir sur la périphérie : un petit-déjeuner rapide, éventuellement pris debout ou emporté, avec un produit céréalier simple (tartine préparée, pain) et un fruit facile à manger.

Normes, valeurs, attitudes

- Une **valeur** est un idéal collectif qui oriente les jugements (santé, plaisir, convivialité, partage, respect de l'animal, économie).
- Une **norme sociale** est une règle de conduite, explicite ou implicite, attendue dans un groupe : manger à heures fixes, finir son assiette, ne pas manger seul devant la télévision… On distingue les normes **descriptives** (« ce que les gens font ») et **injonctives** (« ce qu'il faut faire »). Montrer que « la majorité des familles de l'école donnent de l'eau au goûter » (norme descriptive) est souvent plus efficace qu'une injonction.
- Une **attitude** est une disposition favorable ou défavorable envers un objet (« j'aime / je n'aime pas les légumes secs »), composée d'éléments cognitifs (croyances), affectifs (émotions) et conatifs (intentions d'agir).

Culture, différences culturelles, interculturalité, acculturation

Définition – Culture

Ensemble des manières de penser, de sentir et d'agir, **apprises et partagées** par les membres d'un groupe, et transmises de génération en génération (langue, croyances, valeurs, techniques, cuisine, rites). La culture alimentaire comprend ce qui est mangé, comment, quand, avec qui, et ce que cela signifie.

Les **différences culturelles** portent par exemple sur : la structure du repas (plat unique ou succession d'entrée-plat-dessert), les horaires, l'usage des mains ou des couverts, les aliments interdits ou valorisés, la place des enfants à table, la valeur de la corpulence (signe de santé et de prospérité dans certaines cultures), le rapport au temps du repas, les fêtes et jeûnes.

Définition – Interculturalité

Ensemble des **relations et échanges** entre personnes de cultures différentes, fondés sur la reconnaissance mutuelle et la réciprocité. La **posture interculturelle** du professionnel consiste à prendre conscience de son propre cadre culturel (décentration), à découvrir celui de l'autre sans jugement, et à négocier des solutions acceptables pour les deux (Margalit Cohen-Emerique, 2011).

Définition – Acculturation

Ensemble des changements qui se produisent lorsque des groupes de cultures différentes sont en **contact continu et direct** (Redfield, Linton et Herskovits, 1936). Roger Bastide distingue l'acculturation **spontanée** (non dirigée, par le simple contact : adoption progressive de produits du pays d'accueil) et l'acculturation **planifiée** (organisée volontairement par une institution, par exemple un programme d'éducation alimentaire ou la cantine scolaire). Le **syncrétisme culinaire** désigne la combinaison d'éléments de cultures différentes dans une même pratique (couscous aux légumes de saison français, « burger » maison avec épices du pays d'origine).

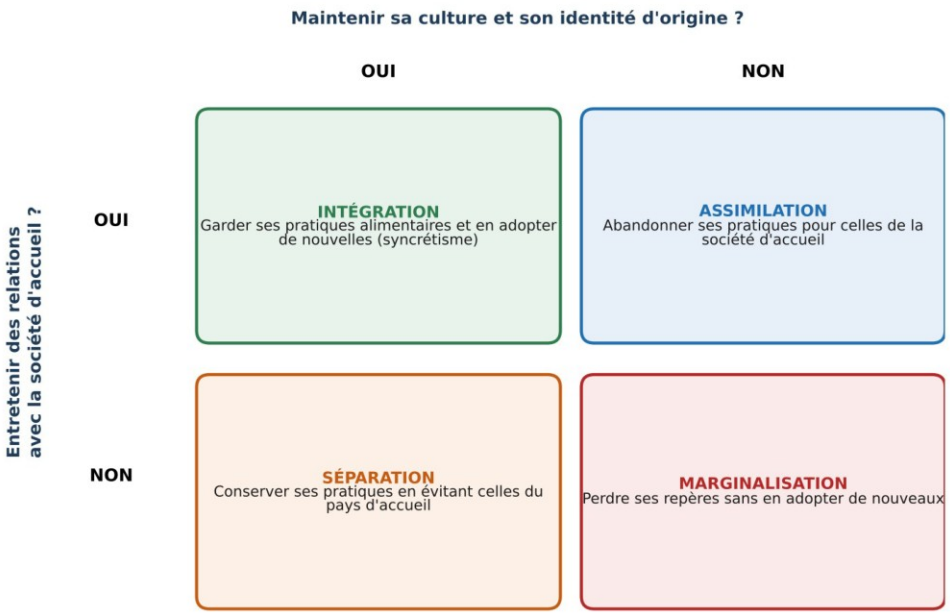


Figure 3.2 – Les stratégies d'acculturation selon John Berry (1997), appliquées à l'alimentation

Comprendre le schéma – Figure 3.2

1. Le modèle croise deux questions : la personne **maintient-elle** sa culture d'origine ? **Entretient-elle** des relations avec la société d'accueil ?

2. Intégration (oui / oui) : on garde ses plats et on en adopte de nouveaux ; c'est la stratégie généralement la plus favorable au bien-être et à la santé.

3. Assimilation (non / oui) : abandon des pratiques d'origine ; en alimentation, elle s'accompagne souvent de l'adoption de produits transformés, de sodas et de restauration rapide, avec un risque de dégradation de la qualité nutritionnelle (« transition nutritionnelle »).

4. Séparation (oui / non) : maintien des pratiques d'origine sans contact avec celles du pays d'accueil ; difficultés possibles d'accès aux produits.

5. Marginalisation (non / non) : perte des repères sans en adopter de nouveaux ; situation de grande vulnérabilité, y compris alimentaire.

6. Pour le diététicien : favoriser l'**intégration** en valorisant les pratiques d'origine favorables (légumineuses, légumes, cuisine maison) et en aidant à utiliser les produits disponibles.

Attention – Respecter sans enfermer

Ne pas réduire une personne à sa culture supposée (« les Africains mangent… ») : il existe une grande diversité à l'intérieur de chaque groupe. On **demande** à la personne ce qu'elle mange et ce qui compte pour elle, plutôt que de le présumer.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.5

Lors d'un atelier, Mme A., arrivée du Mali il y a deux ans, explique qu'elle cuisine le tiep (riz au poisson et aux légumes) le week-end, mais que ses enfants réclament des nuggets et des sodas « comme à la cantine et chez les copains ». a) Identifiez les mécanismes de socialisation en jeu. b) Situez la famille dans le modèle de Berry. c) Proposez une attitude et une action.

Corrigé

a) Socialisation **primaire** (transmission du tiep par la mère) et socialisation **secondaire** des enfants par l'école, la cantine et les **pairs**, qui introduit de nouvelles normes et de nouveaux produits (acculturation **spontanée**). **b)** La famille est en situation d'**intégration** (la mère maintient ses plats et s'ouvre aux produits français), avec un risque d'**assimilation** des enfants vers des produits transformés peu favorables. **c)** Attitude : valoriser le tiep (plat complet riche en légumes et en poisson), sans dévaloriser les demandes des enfants. Action : atelier « recettes du monde » où la mère présente le tiep au groupe (valorisation identitaire) et atelier « nuggets maison au four » pour répondre aux envies des enfants avec une version plus favorable (syncrétisme).

Ethnocentrisme, relativisme et démarche interculturelle

- L'**ethnocentrisme** est la tendance à juger les autres cultures à partir des normes de la sienne, considérées comme les seules « normales » (« en France, on mange de tout, les enfants doivent s'adapter »).
- Le **relativisme culturel** considère que chaque pratique a un sens dans sa culture et doit être comprise avant d'être jugée. Poussé à l'extrême, il pourrait conduire à tout accepter, y compris ce qui nuit à la santé : le professionnel garde ses repères (sécurité sanitaire, droits des personnes) tout en cherchant à comprendre.
- Le **choc culturel** est la réaction (incompréhension, malaise, irritation) que provoque la rencontre d'une pratique très différente. Margalit Cohen-Emerique a montré qu'il touche des **zones sensibles** : le corps et sa présentation, le rapport au temps, la place de la famille et des femmes, la religion, la façon de soigner et de nourrir les enfants.

Méthode pas à pas – La démarche interculturelle en trois étapes (Cohen-Emerique, 2011)

1. Décentration : prendre conscience de son propre cadre de référence (valeurs, normes, préjugés) et de ses réactions face à la situation. « Pourquoi cette pratique me choque-t-elle ? »

2. Découverte du cadre de référence de l'autre : chercher à comprendre le sens de la pratique pour la personne, en l'interrogeant sans supposer. « Que représente pour vous ce repas, ce jeûne, cet aliment ? »

3. Négociation et médiation : chercher ensemble une solution acceptable pour les deux parties, qui respecte l'identité de la personne et les impératifs professionnels (santé, sécurité, règlement).

Exemple – Le jeûne du ramadan chez une personne diabétique

M. K., diabétique de type 2 traité par comprimés, annonce à la diététicienne qu'il fera le ramadan. **Décentration** : la diététicienne repère sa première réaction (« c'est dangereux, il ne doit pas jeûner »), liée à son cadre médical. **Découverte** : elle apprend que le jeûne a pour lui une grande valeur spirituelle et familiale, et qu'il l'a toujours fait. **Négociation** : elle l'oriente vers son médecin pour adapter le traitement et la surveillance de la glycémie, et travaille avec lui la composition des repas de rupture du jeûne et du repas avant l'aube (féculents complets, légumineuses, eau en quantité suffisante, dattes en quantité raisonnable). Le jeûne n'est ni interdit ni ignoré : il est accompagné.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.6

Dans une crèche, une mère d'origine sénégalaise donne à son fils de 18 mois un biberon de bouillie très sucrée le soir. L'auxiliaire de puériculture dit : « Ce n'est pas comme ça qu'on fait ici. » a) Identifiez l'attitude de l'auxiliaire. b) Appliquez les trois étapes de la démarche interculturelle. c) Proposez une solution négociée.

Corrigé

a) Une attitude **ethnocentrique** : la pratique est jugée à partir des normes de l'auxiliaire et de l'institution, sans chercher à la comprendre. **b)** Décentration : l'auxiliaire repère que, pour elle, la « bonne » alimentation d'un enfant de 18 mois passe par des repas à la cuillère et peu de sucre. Découverte : elle interroge la mère, qui explique que la bouillie du soir aide l'enfant à dormir et qu'elle a été élevée ainsi ; elle craint qu'il ait faim

la nuit. Négociation : on part de l'objectif commun (un enfant qui dort bien et qui n'a pas faim). **c)** Garder le repas du soir rassasiant, mais remplacer peu à peu la bouillie sucrée par une bouillie de céréales non sucrée ou peu sucrée, avec du lait ou un fruit écrasé, donnée à la cuillère quand c'est possible, et parler du brossage des dents. La mère choisit le rythme du changement.

Pratiques alimentaires religieuses : connaître pour adapter

Dans un atelier, le respect des pratiques religieuses et culturelles conditionne la participation. Le diététicien ne suppose rien à partir de l'origine ou du nom d'une personne : il **demande**, car les pratiques varient beaucoup d'une personne à l'autre au sein d'une même religion.

Les règles des grandes traditions religieuses (islam, judaïsme, christianisme, hindouisme, bouddhisme, sikhisme, jaïnisme) et la question de la laïcité en restauration collective sont présentées au chapitre 4 (section 4.3.15). On retient ici la posture : ces règles sont aussi des **marqueurs d'identité** (section 3.3.2) ; les respecter évite la **menace identitaire** et favorise la stratégie d'**intégration** de Berry. En restauration scolaire, les menus de substitution ne sont ni obligatoires ni interdits ; le Conseil d'État (11 décembre 2020) a jugé qu'une commune qui décide de les supprimer doit tenir compte de l'intérêt des enfants.

Méthode pas à pas – Préparer un atelier interculturel respectueux

1. À l'inscription, demander simplement : « Y a-t-il des aliments que vous ne mangez pas, pour des raisons de santé, de religion ou de goût ? »
2. Construire la recette de base avec des ingrédients acceptables par tous (légumes, légumineuses, céréales, épices).
3. Prévoir les éventuelles variantes à part (viande halal, fromage) plutôt que de les mélanger.
4. Vérifier les ingrédients cachés : gélatine, bouillon, vin, saindoux, présure.
5. Tenir compte du calendrier (ramadan, carême, fêtes) pour fixer les dates et les horaires.
6. Valoriser les plats et les savoir-faire des participants (stratégie d'**intégration** de Berry).

À vous de jouer – Exercice d'application 3.7

Un centre social prévoit un atelier « gratin de fin d'été » (pommes de terre, lardons, crème, emmental) un vendredi soir de mars. Parmi les 10 inscrits, 4 personnes ne mangent pas de porc, une famille est orthodoxe et une personne ne consomme aucun produit d'origine animale. a) Repérez les difficultés. b) Proposez une recette et une organisation adaptées. c) Quelle phrase utilisez-vous à l'inscription pour éviter ces difficultés ?

Corrigé

a) Les **lardons** excluent les personnes qui ne mangent pas de porc ; un vendredi de mars peut tomber en période de **carême** (jeûne orthodoxe sans produits animaux, abstinence de viande pour certains catholiques) ; la crème et l'emmental excluent la personne végétalienne ; le « gratin de fin d'été » est hors saison en mars. **b)** Un **gratin de légumes de saison et de pois chiches** à base de lait végétal et de chapelure, avec une petite portion gratinée au fromage préparée à part pour ceux qui le souhaitent ; aucun produit carné. **c)** « Y a-t-il des aliments que vous ne mangez pas, pour des raisons de santé, de religion ou de goût ? », posée à tous, sans demander de justification.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 3.3.3 – Représentations, normes, culture

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Définissez une représentation sociale et citez son auteur fondateur.
2. Nommez les deux processus de formation d'une représentation.

3. Distinguez noyau central et éléments périphériques.
4. Distinguez norme descriptive et norme injonctive, avec un exemple alimentaire.
5. Citez les quatre stratégies d'acculturation de Berry.
6. Qu'est-ce que l'ethnocentrisme ? Pourquoi est-il un risque pour le diététicien ?

Corrigé – Point d'étape 3.3.3

1. Une connaissance de sens commun, partagée par un groupe, socialement construite, qui guide les conduites (Serge Moscovici, 1961).
2. L'objectivation (rendre concret un concept abstrait) et l'ancrage (l'intégrer dans des catégories déjà connues).
3. Le noyau central est stable, consensuel, résistant et donne son sens à la représentation ; les éléments périphériques sont plus souples, liés au contexte, et changent en premier.
4. Descriptive : ce que font la plupart des gens (« 7 familles sur 10 servent des légumes le soir »). Injonctive : ce qu'il faut faire, ce qui est approuvé (« il faut manger des légumes »).
5. Intégration, assimilation, séparation, marginalisation.
6. Juger les pratiques des autres cultures à partir des normes de sa propre culture ; il conduit à des conseils inadaptés et à la perte de confiance du public.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

3.3.4 La relation sociale et ses dynamiques

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M5 S2 §1 (p. 35 et 36) ; Synthèse M5 S2 §2 (p. 36 à 38)

Le groupe et l'influence sociale

Définition – Groupe

Ensemble de personnes en **interaction**, qui partagent des objectifs, des normes et un sentiment d'appartenance, et dont les membres s'influencent mutuellement. Kurt Lewin (années 1940) a fondé l'étude de la **dynamique des groupes** : le groupe est un tout dont les propriétés dépassent la somme des individus.

Exemple – L'expérience fondatrice de Kurt Lewin (1943)

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les autorités américaines voulaient que les ménagères cuisinent des **abats** (moins chers, disponibles) à la place des morceaux nobles de viande. Lewin a comparé deux méthodes : des **conférences** persuasives données par un expert, et des **discussions de groupe** où les participantes échangeaient puis décidaient collectivement. Résultat : environ **3 %** des femmes ayant assisté aux conférences ont ensuite cuisiné des abats, contre environ **32 %** de celles qui avaient participé aux discussions de groupe et pris une décision publique. **Leçons pour le diététicien** : la **participation** et la **décision prise en groupe** (engagement) changent davantage les comportements que l'information descendante ; c'est le fondement de l'approche participative en éducation pour la santé (chapitre 1).

Phénomène	Définition	Application en atelier
Conformisme (Asch, 1951)	Tendance à aligner son jugement ou son comportement sur celui du groupe, même s'il paraît erroné	Un participant n'ose pas goûter si les autres refusent : faire goûter l'animateur et un « leader » positif en premier
Soumission à l'autorité (Milgram, 1963)	Tendance à obéir à une figure d'autorité	La blouse ou le statut de professionnel donnent du poids aux paroles : éviter l'injonction, privilégier l'échange
Influence minoritaire (Moscovici, 1969)	Une minorité cohérente et constante peut faire évoluer la majorité	Quelques parents convaincus peuvent faire évoluer les goûters de toute une classe
Facilitation sociale	On mange en moyenne davantage à plusieurs que seul	Repas partagés pour stimuler l'appétit des personnes âgées dénutries
Normes du groupe	Règles implicites partagées	Définir avec le groupe ses règles (bienveillance, droit de ne pas aimer, confidentialité)

Comment naît une norme de groupe : quatre expériences classiques

Le tableau précédent résume les grands phénomènes d'influence. Il est utile de connaître les expériences qui les ont mis en évidence, car le jury attend des références précises et datées.

Expérience	Ce qui a été fait	Résultat principal	Leçon pour l'atelier
Effet autocinétique (Muzafer Sherif, 1935)	Dans une pièce noire, un point lumineux fixe paraît bouger. Chacun estime d'abord seul le déplacement, puis en groupe.	Les estimations individuelles, très différentes au départ, convergent vers une **norme commune** qui persiste ensuite quand la personne est de nouveau seule.	Face à une situation nouvelle (un aliment inconnu), le groupe fabrique sa propre norme : les premiers avis exprimés comptent beaucoup.
Lignes de Solomon Asch (1951)	Un participant naïf doit dire quelle ligne a la même longueur qu'une ligne modèle, après plusieurs complices qui donnent une réponse fausse.	Environ un tiers des réponses suivent la majorité erronée, et environ trois participants sur quatre se conforment au moins une fois. Il suffit d'**un seul allié** qui donne la bonne réponse pour que le conformisme chute fortement.	Un seul participant qui ose dire « j'aime bien » ou « je goûte » libère les autres.
Facilitation sociale (Norman Triplett, 1898 ; Robert Zajonc, 1965)	Comparaison de performances réalisées seul ou en présence d'autres personnes.	La présence d'autrui améliore les tâches **simples et maîtrisées** et gêne les tâches **complexes ou nouvelles**.	Un geste culinaire nouveau s'apprend mieux en petit binôme que devant tout le groupe.
Apprentissage par observation (Albert Bandura, 1961 ; théorie de l'apprentissage social, 1977)	Des enfants observent un adulte qui frappe ou non une poupée, puis sont laissés seuls avec elle.	Les enfants reproduisent le comportement observé, surtout si le modèle leur ressemble ou est valorisé.	Le **modèle** (animateur, pair, parent) qui goûte et cuisine est un puissant levier.

Exemple – Manger à plusieurs : la facilitation sociale de la prise alimentaire

Le psychologue John de Castro a fait tenir des carnets alimentaires détaillés à des adultes pendant sept jours. Les repas pris avec d'autres personnes étaient en moyenne **44 % plus importants** que les repas pris seul (de Castro et Brewer, 1992), et la quantité augmentait avec le nombre de convives. Ce résultat a deux usages opposés :

- en **gériatrie** ou en EHPAD, le repas partagé est un outil contre la **dénutrition** (chapitre 4) : mieux vaut une table conviviale qu'un plateau en chambre quand c'est possible ;
- dans un atelier destiné à des adultes qui veulent mieux réguler leurs apports, on parle des repas de fête et des buffets sans culpabiliser, en travaillant les signaux de faim et de rassasiement.

Définition – Influence informationnelle et influence normative (Deutsch et Gerard, 1955)

- L'**influence informationnelle** : on suit le groupe parce qu'on pense qu'il a raison (« s'ils trouvent cela bon, c'est sûrement bon »). Elle est forte quand la situation est **ambiguë** ou nouvelle (expérience de Sherif). Elle produit un changement durable, même en privé.
- L'**influence normative** : on suit le groupe pour être accepté et éviter le rejet (expérience d'Asch). Elle produit surtout un changement **public**, qui peut disparaître quand la personne est seule.

Conséquence : une dégustation « parce que tout le monde goûte » (normative) change peu les habitudes à la maison ; une dégustation suivie d'un échange sur le goût et la recette (informationnelle) a plus de chances de durer.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.8

Lors d'un atelier en foyer de jeunes travailleurs, l'animatrice propose un houmous de pois chiches. Le premier jeune à qui elle tend la cuillère dit « Beurk, ça a l'air bizarre ». Les cinq suivants refusent aussi. a) Quel phénomène observe-t-on ? Citez l'expérience correspondante. b) Quel type d'influence domine ici ? c) Proposez deux façons d'organiser la dégustation pour limiter cet effet.

Corrigé

a) C'est un **conformisme** : les jeunes alignent leur comportement sur le premier avis exprimé (Asch, 1951 ; la première réponse fixe aussi une norme, comme chez Sherif, 1935). **b)** Surtout une **influence normative** : on refuse pour ne pas se démarquer devant les autres, plus que parce qu'on est convaincu que le houmous est mauvais. **c)** Faire goûter d'abord l'animatrice et un jeune volontaire connu pour être curieux (un **allié** suffit à réduire le conformisme) ; faire goûter **en même temps** et en silence, puis noter son avis sur une fiche avant d'en parler ; présenter le plat avec des repères familiers (pain pita, crudités à tremper).

Attitudes, dissonance cognitive et engagement

Définition – Dissonance cognitive (Leon Festinger, 1957)

État d'inconfort ressenti lorsqu'une personne a des cognitions (pensées, croyances, comportements) **contradictoires** (« je fume / fumer tue »). Pour réduire cet inconfort, elle modifie l'une des cognitions : changer son comportement… ou, plus souvent, **rationaliser** (« mon grand-père a fumé et a vécu vieux »). Les messages culpabilisants augmentent la dissonance et provoquent souvent le rejet du message.

Définition – Engagement (Kiesler, 1971 ; Joule et Beauvois, 1987)

Lien qui unit une personne à ses actes. Un acte réalisé **librement**, **publiquement**, de façon **répétée** et **coûteuse** engage davantage la personne et favorise le maintien du comportement. La technique du **pied-dans-la-porte** consiste à obtenir d'abord un petit acte (goûter une cuillère de lentilles) avant une demande plus importante (cuisiner une recette à la maison).

Lien diététique – Appliquer l'engagement en atelier

- Faire **choisir librement** une recette à refaire à la maison (« vous êtes libre de… » augmente l'engagement).
- Faire énoncer un petit **objectif personnel** devant le groupe (« je vais essayer les lentilles une fois cette semaine »).
- Revenir sur cet engagement à la séance suivante, en valorisant chaque essai.
- Rester **éthique** : ces techniques servent l'intérêt de la personne et ne doivent jamais manipuler ni

contraindre (chapitre 6).

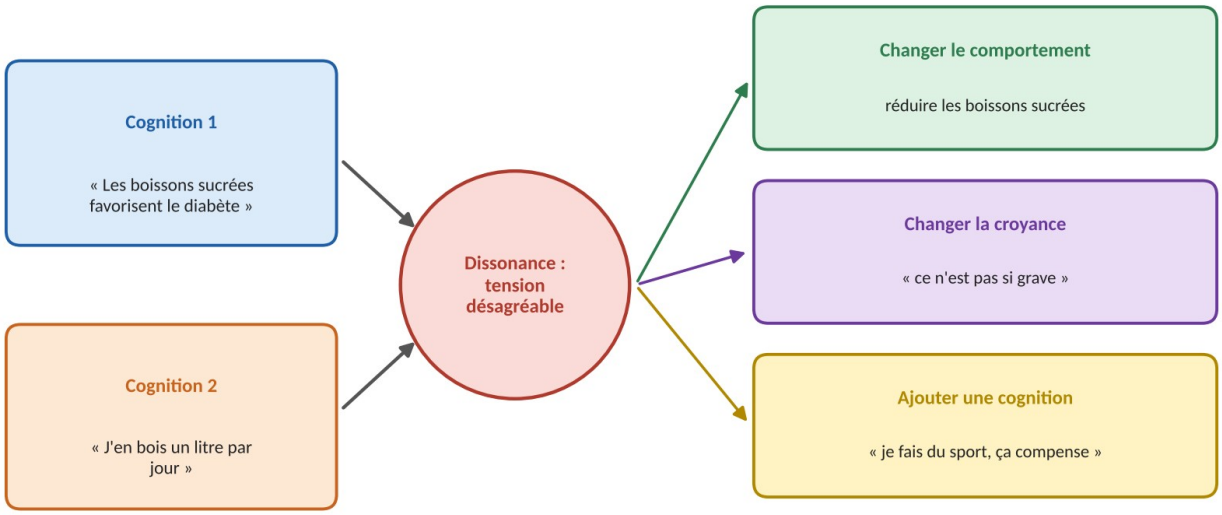


Figure 3.2 bis – La dissonance cognitive et ses trois issues

Comprendre le schéma – Figure 3.2 bis

1. À gauche, deux **cognitions** qui se contredisent : une connaissance (« les boissons sucrées favorisent le diabète ») et un comportement (« j'en bois un litre par jour »).
2. Au centre, la **dissonance** : un état d'inconfort désagréable que la personne cherche à réduire.
3. À droite, trois issues possibles : **changer le comportement** (réduire les boissons sucrées : la seule issue qui intéresse la santé publique), **changer la croyance** (« ce n'est pas si grave ») ou **ajouter une cognition** qui justifie (« je fais du sport, ça compense »).
4. Les deux dernières issues sont les plus faciles, donc les plus fréquentes : un message qui augmente fortement la dissonance sans donner de moyen d'agir pousse vers le déni plutôt que vers le changement.

Deux expériences fondatrices sur la dissonance et l'engagement

Exemple – L'expérience de Festinger et Carlsmith (1959)

Des étudiants réalisent pendant une heure une tâche très ennuyeuse (tourner des chevilles sur une planche). On leur demande ensuite de dire à l'étudiant suivant que la tâche était intéressante. Certains reçoivent **1 dollar** pour ce mensonge, d'autres **20 dollars**. Interrogés ensuite, ceux qui ont reçu 1 dollar jugent la tâche **plus agréable** que ceux qui ont reçu 20 dollars et que les étudiants d'un groupe témoin.

Explication : avec 20 dollars, le mensonge est justifié par l'argent ; avec 1 dollar, il ne l'est pas, et la seule façon de réduire la dissonance est de changer d'avis sur la tâche. **Leçon** : une petite incitation, ou aucune, engage davantage qu'une grosse récompense ; c'est un argument de plus contre les récompenses en éducation nutritionnelle (section 3.3.11).

Exemple – Le pied-dans-la-porte (Freedman et Fraser, 1966)

Des chercheurs demandent à des propriétaires californiens d'installer dans leur jardin un grand panneau peu esthétique « Conduisez prudemment ». Sans préparation, **16,7 %** acceptent (groupe témoin). Dans un autre groupe, on avait demandé deux semaines plus tôt de coller un petit autocollant sur le même thème, ce que presque tous avaient accepté. Dans ce groupe, **76 %** acceptent ensuite le grand panneau.

Leçon : obtenir d'abord un petit acte, librement consenti, rend plus probable un acte plus important. En

atelier, on demande d'abord de goûter une cuillère, puis de choisir une recette à refaire.

Technique d'engagement	Principe	Exemple éthique en nutrition
Pied-dans-la-porte	Un petit acte préalable facilite une demande plus coûteuse.	Goûter une cuillère de soupe de légumes, puis noter la recette pour la refaire.
Porte-au-nez (Cialdini et collaborateurs, 1975)	Après le refus d'une demande excessive, une demande modérée est plus souvent acceptée (dans l'expérience originale, 50 % contre 16,7 % sans demande préalable).	« Vous pourriez cuisiner tous les soirs ? Non ? Alors une fois cette semaine ? » À utiliser avec prudence : la première demande ne doit pas être culpabilisante.
Déclaration de liberté (« vous êtes libre de… »)	Rappeler la liberté de refuser augmente l'acceptation et l'engagement.	« Vous êtes libre de goûter ou non. »
Engagement public	Un engagement annoncé devant d'autres est mieux tenu qu'un engagement privé.	Chacun dit au groupe le petit changement qu'il essaiera.
Communication engageante (Joule, Girandola et Bernard, 2007)	Associer un message de prévention à un **acte** préparatoire (signer, choisir, essayer) plutôt qu'au message seul.	Après l'exposé sur l'eau, chaque élève remplit sa gourde et la décore.

Définition – Amorçage

L'**amorçage** est l'effet d'un premier stimulus, souvent non remarqué, sur une réaction qui suit. Une affiche colorée de légumes à l'entrée du self, l'odeur du pain chaud ou la place d'un produit au début de la ligne de service peuvent orienter les choix sans que la personne s'en rende compte. C'est la base de nombreux **nudges** (section 3.3.11 et chapitre 6). Les effets d'amorçage sont souvent plus faibles et moins reproductibles qu'on ne l'a cru : on les évalue toujours sur le terrain.

Attention – Engager sans manipuler

Les techniques d'engagement sont puissantes. Elles sont éthiques si elles servent l'**intérêt de la personne**, si l'objectif est **transparent** (la personne pourrait l'accepter si on le lui expliquait) et si la personne garde sa **liberté** de refuser. Elles deviennent de la manipulation quand elles servent un intérêt commercial ou institutionnel caché, ou quand on exploite la honte et la peur (chapitre 6).

À vous de jouer – Exercice d'application 3.9

Un collège veut que les élèves boivent davantage d'eau. Le principal propose de distribuer un bon d'achat de 10 € aux élèves qui viennent avec une gourde pendant un mois. a) Que prévoit la théorie de la dissonance sur l'effet à long terme de cette récompense ? b) Proposez une action fondée sur l'engagement à la place. c) À quelles conditions cette action reste-t-elle éthique ?

Corrigé

a) La récompense importante fournit une **justification externe** (« je prends ma gourde pour le bon d'achat ») : comme dans l'expérience de Festinger et Carlsmith, l'attitude envers l'eau change peu, et le comportement risque de s'arrêter avec la récompense. **b)** Un **pied-dans-la-porte** : chaque élève choisit et décore librement sa gourde en classe (petit acte, libre, public), puis le groupe décide d'un défi « une gourde pleine par jour » avec un suivi collectif ; on rappelle la liberté de participer. **c)** L'objectif est connu des élèves

> et de leurs familles, la participation est libre, aucun élève n'est montré du doigt, et l'action sert leur santé (pas une marque d'eau).

Stéréotypes, préjugés, discrimination, stigmatisation

- **Stéréotype** : croyance généralisée sur les caractéristiques d'un groupe (« les personnes obèses manquent de volonté »).
- **Préjugé** : attitude (souvent négative) envers les membres d'un groupe.
- **Discrimination** : comportement défavorable envers une personne en raison de son appartenance réelle ou supposée à un groupe (interdite par la loi pour plus de 25 critères, dont l'apparence physique).
- **Stigmatisation** (Erving Goffman, 1963) : processus par lequel une caractéristique (le poids, la pauvreté, l'origine) disqualifie la personne et la réduit à cet attribut. La **stigmatisation du poids** augmente le stress, l'évitement des soins, les comportements alimentaires désordonnés et la prise de poids.

Juger autrui : théories implicites, fonctions des stéréotypes et des préjugés

- Les **théories implicites de la personnalité** (TIP), décrites par Jerome Bruner et Renato Tagiuri (1954), sont les croyances « naïves » qui nous font déduire la personnalité d'une personne à partir de quelques indices (« il est gros, donc il manque de volonté »). Elles ne sont pas vérifiées scientifiquement.
- Les **stéréotypes** ont trois fonctions : **expliquer** un événement (en désignant un groupe responsable), **justifier** un comportement envers ce groupe, **anticiper** ce que l'autre va faire.
- Les **préjugés** ont trois fonctions : **différencier** son groupe des autres, **économiser** l'effort de réflexion, **rationaliser** en servant de norme au groupe.
- La **discrimination** est le comportement qui en découle (Myers et Lamarche) : traiter différemment une personne à cause de son groupe. En droit français, elle est interdite pour plus de vingt critères, dont l'apparence physique et l'état de santé (article 225-1 du Code pénal).

Communiquer : modèle, distances, états du moi et rumeurs

- **Modèle de Shannon et Weaver (1949)** : un émetteur code un message, qui passe par un canal jusqu'à un récepteur qui le décode ; des **bruits** peuvent le déformer. Le schéma de la communication de la section 3.3.8 le complète par la rétroaction.
- **Trois images** guident notre façon d'entrer en relation : le **moi intime** (ce que je pense être), le **moi public** (ce que je veux montrer) et la **représentation d'autrui** (l'image que j'ai de l'autre).
- **Proxémie** (Edward T. Hall, 1966) : chacun règle la distance selon la relation. Repères : distance **intime** (moins de 45 cm), **personnelle** (45 cm à 1,2 m), **sociale** (1,2 à 3,6 m), **publique** (au-delà de 3,6 m). La **place** occupée compte aussi : face à face (confrontation), côte à côte (coopération).
- **Analyse transactionnelle** (Eric Berne, années 1960) : chaque personne passe par trois **états du moi**, **Parent** (règles, protection), **Adulte** (faits, raisonnement), **Enfant** (émotions, spontanéité). Un conseil donné sur le ton du Parent (« vous devez ») appelle souvent une réponse de l'Enfant (révolte ou soumission) ; l'entretien éducatif vise un échange Adulte-Adulte.
- **Rumeurs** : Gordon Allport et Leo Postman (1947) ont montré qu'un récit transmis de bouche à oreille perd la plupart de ses détails après cinq ou six personnes. Trois mécanismes le déforment : la **réduction** (on oublie), l'**accentuation** (on grossit certains détails) et l'**assimilation** (on adapte le récit à ses attentes et à ses stéréotypes). Une rumeur réussit quand l'information est frappante, la source jugée crédible et le démenti difficile.

> **À vous de jouer – Exercice d'application 3.10**
>
> Dans un collège, une rumeur circule : « La viande de la cantine est périmée ; un élève a été malade. » La fréquentation baisse de 412 à 338 repas par jour. a) Calculez la baisse en nombre et en pourcentage. b) Nommez deux mécanismes de déformation probables. c) Proposez une réponse de la diététicienne.

Corrigé

a) 412 − 338 = **74 repas** ; 74 / 412 × 100 = **18,0 %** de baisse. b) **Accentuation** (un malaise isolé devient « la viande périmée ») et **assimilation** (le récit confirme le stéréotype « la cantine, c'est mauvais »). c) Ne pas nier en bloc, ce qui renforcerait la rumeur ; donner des **faits vérifiables** (traçabilité, dates limites, résultats du dernier contrôle), inviter des parents et des délégués à visiter la cuisine, faire goûter, et s'appuyer sur des **élèves relais** crédibles pour leurs pairs.

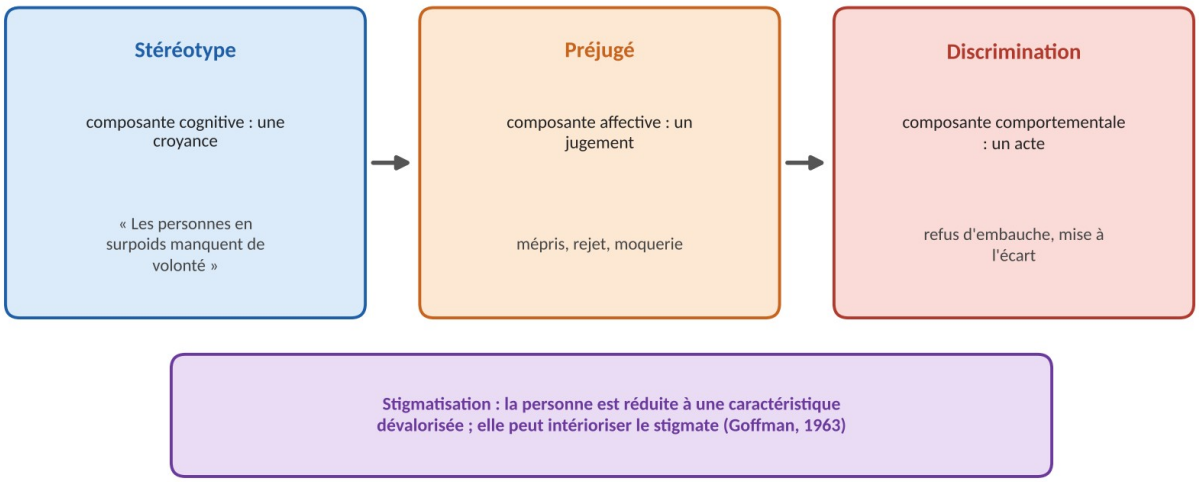


Figure 3.2 ter – Du stéréotype à la discrimination

Comprendre le schéma – Figure 3.2 ter

1. Le **stéréotype** est une **croyance** : il relève de la pensée (« les personnes en surpoids ne font pas d'efforts »).
2. Le **préjugé** est une **attitude**, chargée d'émotion : il relève du jugement (« elles m'agacent », mépris, gêne).
3. La **discrimination** est un **comportement** : traiter moins bien une personne à cause de son appartenance réelle ou supposée à un groupe (ne pas l'embaucher, lui parler avec condescendance, ne pas l'examiner).
4. En bas, la **stigmatisation** englobe tout le processus : la personne est réduite à une caractéristique dévalorisée, et elle peut finir par **intérioriser le stigmate** (Goffman, 1963), c'est-à-dire se dévaloriser elle-même. Le stigmate s'installe aussi dans les institutions (mobilier inadapté, messages de campagne humiliants).
5. Les flèches ne sont pas automatiques : on peut connaître un stéréotype sans y adhérer, et le cadre professionnel (déontologie, formation) peut empêcher le passage au comportement.

La menace du stéréotype

Exemple – Steele et Aronson (1995)

Des étudiants afro-américains et blancs de l'université Stanford passent un test difficile de compréhension verbale. Quand le test est présenté comme une mesure des **capacités intellectuelles**, les étudiants afro-américains réussissent moins bien que les étudiants blancs de même niveau. Quand le **même test** est présenté comme un simple exercice de laboratoire, l'écart disparaît.

Explication : la peur de confirmer un stéréotype négatif sur son groupe crée une anxiété qui diminue la performance. Le même effet a été observé chez des femmes dans des tests de mathématiques (Spencer, Steele et Quinn, 1999).

En nutrition : une personne en surpoids, à qui l'on rappelle sans cesse qu'elle « manque de volonté », peut se sentir incapable dans un atelier culinaire ou une activité physique, et éviter d'y revenir. Un cadre qui ne

renvoie pas au poids protège la participation.

À retenir – Les effets de la stigmatisation du poids

Les revues de la littérature (Puhl et Heuer, 2009 et 2010) montrent que la stigmatisation du poids est répandue, y compris chez les professionnels de santé. Elle ne motive pas à perdre du poids : elle est associée à plus de stress, à une alimentation émotionnelle et à des épisodes d'hyperphagie, à moins d'activité physique, à un **évitement des soins** (rendez-vous annulés, dépistages repoussés) et à une moins bonne estime de soi. Une déclaration internationale de consensus, publiée en 2020 dans *Nature Medicine* (Rubino et collaborateurs), appelle les professionnels et les médias à y mettre fin.

Les biais implicites : les professionnels aussi

Définition – Attitude implicite et test d'association implicite

Une **attitude implicite** est une évaluation automatique, souvent inconsciente, qui peut différer de ce que la personne déclare penser. Le **test d'association implicite** (Greenwald, McGhee et Schwartz, 1998) la mesure à partir des temps de réaction : on associe plus vite deux notions qui sont déjà liées dans la mémoire (par exemple « mince » et « bon »). Une étude menée auprès de près de 400 professionnels spécialistes de l'obésité (Schwartz et collaborateurs, 2003) a montré qu'eux aussi associaient plus facilement les personnes obèses à des adjectifs comme « paresseux » ou « sans valeur ».

Lien diététique – Que faire de ses propres biais ?

Avoir des biais ne fait pas de quelqu'un un mauvais professionnel : ils viennent de la socialisation et des images diffusées par la société. Ce qui compte, c'est de les **connaître** et d'empêcher qu'ils guident les pratiques : utiliser une grille d'entretien identique pour tous, vérifier son langage et ses supports (méthode ci-dessous), s'interroger après une séance difficile (« aurais-je réagi de la même façon avec une autre personne ? »), en parler en analyse de pratiques.

Méthode pas à pas – Vérifier qu'une action ne stigmatise pas

1. **Langage** : dire « une personne vivant avec une obésité » plutôt qu'« un obèse » ; éviter « combat », « lutte contre les kilos », « mauvais aliments ».
2. **Images** : refuser les photos de corps sans tête, de ventres ou de personnes en train de manger seules de la malbouffe ; préférer des personnes de toutes corpulences en activité.
3. **Cible du message** : parler de comportements favorables (cuisiner, bouger, partager un repas) et de leurs bénéfices immédiats, pas du poids.
4. **Environnement** : prévoir des chaises sans accoudoirs et solides, un tablier de grande taille, ne pas peser en public.
5. **Recrutement** : proposer l'action à tous plutôt qu'aux seules « personnes en surpoids » (universalisme proportionné, chapitre 2).
6. **Relecture** : faire relire le support par des personnes concernées avant de le diffuser.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.11

Une mairie prépare une affiche pour un cycle d'ateliers : la photo montre le ventre d'un homme en surpoids qui tient un hamburger, avec le titre « Stop à la malbouffe : reprenez le contrôle de votre poids ! ». a) Relevez trois éléments stigmatisants. b) Expliquez, avec la notion de menace du stéréotype, pourquoi cette affiche risque d'éloigner le public visé. c) Proposez un nouveau titre et une nouvelle image.

Corrigé

a) Un corps **sans tête** réduit la personne à son ventre ; l'association surpoids et « malbouffe » renforce le **stéréotype** de la personne qui mange mal par manque de volonté ; le titre culpabilise (« reprenez le contrôle ») et centre sur le **poids**. **b)** Les personnes concernées se sentent visées et jugées ; la peur de confirmer le stéréotype devant le groupe crée une anxiété qui les dissuade de s'inscrire, ou de revenir après une première séance. **c)** Par exemple « Cuisiner simple, bon et pas cher : venez essayer ! » avec une photo d'un groupe varié (âges, corpulences, origines) en train de cuisiner ensemble.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 3.3.4 – Influence sociale, engagement, stigmatisation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel a été le résultat principal de l'expérience de Lewin (1943) ?
2. Qu'a montré Asch (1951) ? Quel facteur fait chuter le conformisme ?
3. Distinguez influence informationnelle et influence normative.
4. Expliquez le résultat de Festinger et Carlsmith (1959).
5. Décrivez la technique du pied-dans-la-porte avec les chiffres de Freedman et Fraser (1966).
6. Distinguez stéréotype, préjugé et discrimination.

Corrigé – Point d'étape 3.3.4

1. Environ 3 % des femmes ayant assisté aux conférences ont cuisiné des abats, contre environ 32 % après une discussion et une décision de groupe.
2. Environ un tiers des réponses suivent une majorité qui se trompe ; la présence d'un seul allié qui donne la bonne réponse fait fortement chuter le conformisme.
3. Informationnelle : on suit le groupe parce qu'on pense qu'il a raison ; changement durable. Normative : on le suit pour être accepté ; changement surtout public.
4. Les étudiants payés 1 dollar pour mentir ont jugé la tâche plus agréable que ceux payés 20 dollars : sans justification externe, ils ont réduit la dissonance en changeant d'avis.
5. Obtenir d'abord un petit acte (un autocollant) rend plus probable un acte plus coûteux : 76 % ont accepté le grand panneau, contre 16,7 % sans demande préalable.
6. Stéréotype : une croyance sur un groupe ; préjugé : une attitude, un jugement affectif ; discrimination : un comportement défavorable.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

3.3.5 Les compétences psychosociales

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

Définition – Compétences psychosociales (CPS)

Selon Santé publique France (2022), les CPS sont « un ensemble cohérent et interrelié de capacités psychologiques (cognitives, émotionnelles et sociales), impliquant des connaissances, des processus intrapsychiques et des comportements spécifiques, qui permettent d'augmenter l'autonomisation et le

pouvoir d'agir, de maintenir un état de bien-être psychique, de favoriser un fonctionnement individuel optimal et de développer des interactions constructives ». L'OMS les avait définies en 1993 comme la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne, et en avait proposé une liste de 10 (en 5 couples).

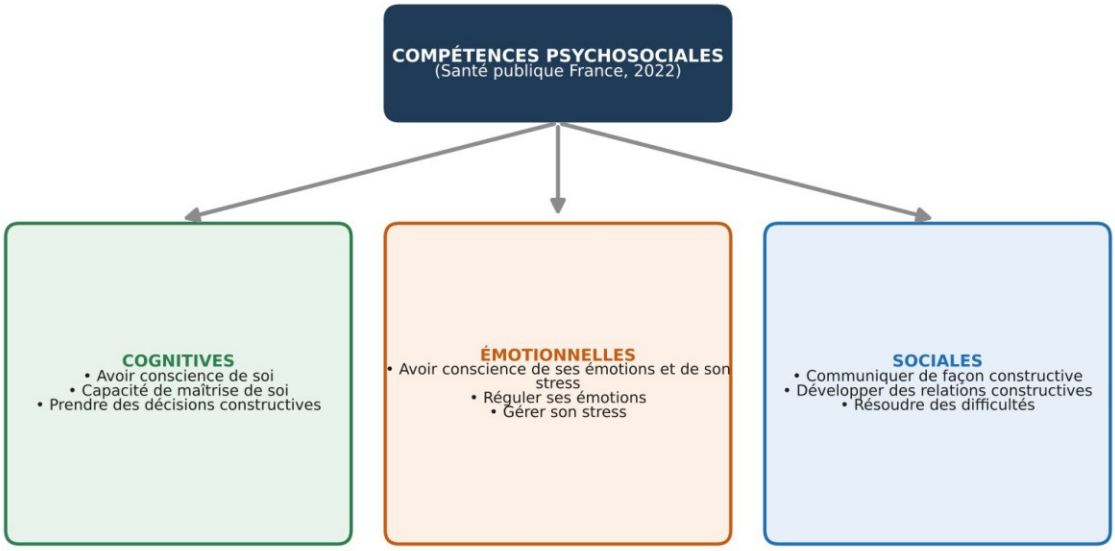


Figure 3.3 – Les 9 compétences psychosociales générales (Santé publique France, 2022)

Comprendre le schéma – Figure 3.3

1. Le référentiel de Santé publique France organise les CPS en **trois catégories**, chacune comportant **trois CPS générales**, elles-mêmes déclinées en CPS spécifiques (une vingtaine au total).
2. **Cognitives** : avoir conscience de soi (connaissance de soi, pensée critique), capacité de maîtrise de soi, prendre des décisions constructives.
3. **Émotionnelles** : avoir conscience de ses émotions et de son stress, réguler ses émotions, gérer son stress.
4. **Sociales** : communiquer de façon constructive (écoute empathique, communication efficace), développer des relations constructives, résoudre des difficultés (demander de l'aide, résoudre des conflits).
5. Les CPS sont un **déterminant majeur** de la santé et du bien-être ; leur développement chez les enfants et les jeunes est une priorité nationale (stratégie interministérielle 2022-2037). Les programmes efficaces sont **structurés**, **interactifs**, **répétés** et animés par des professionnels formés.

CPS	Exemple d'activité en lien avec l'alimentation
Pensée critique	Analyser une publicité pour un produit sucré destiné aux enfants : que cherche-t-elle à me faire croire ?
Prise de décision	Composer un menu à 10 € pour 4 personnes en arbitrant goût, prix et équilibre
Conscience et régulation des émotions	Repérer la différence entre faim physique et envie de manger liée à l'ennui ou au stress ; échelle de la faim
Gestion du stress	Proposer d'autres réponses que la nourriture au stress (respiration, marche, parler à quelqu'un)
Communication constructive	Jeu de rôle : dire non poliment à une seconde portion ou à un soda proposé par un ami
Relations constructives	Cuisiner en binôme, répartir les tâches, s'entraider

CPS	Exemple d'activité en lien avec l'alimentation
Estime de soi (conscience de soi)	Valoriser chaque réussite culinaire ; photographier et exposer les plats réalisés (avec accord)

De la liste de l'OMS (1993) au référentiel de Santé publique France (2022)

La première liste de compétences psychosociales a été publiée par l'OMS en 1993, dans un document destiné aux écoles (*Life skills education in schools*). Elle comptait **10 compétences regroupées en 5 couples**. Elle est encore très citée dans les projets et dans les sujets d'examen : il faut savoir la relier au référentiel actuel.

Couple de CPS (OMS, 1993)	Correspondance dans le référentiel de Santé publique France (2022)
Savoir résoudre des problèmes / savoir prendre des décisions	Compétences cognitives : prendre des décisions constructives ; compétences sociales : résoudre des difficultés
Avoir une pensée créative / avoir une pensée critique	Compétences cognitives : avoir conscience de soi (pensée critique)
Savoir communiquer efficacement / être habile dans les relations interpersonnelles	Compétences sociales : communiquer de façon constructive, développer des relations constructives
Avoir conscience de soi / avoir de l'empathie pour les autres	Compétences cognitives : avoir conscience de soi ; compétences sociales : écoute empathique
Savoir gérer son stress / savoir gérer ses émotions	Compétences émotionnelles : avoir conscience de ses émotions et de son stress, réguler ses émotions, gérer son stress

À retenir – Pourquoi un nouveau référentiel en 2022 ?

Santé publique France a actualisé la liste de l'OMS à partir des connaissances scientifiques récentes. Le référentiel de 2022 distingue trois **catégories** (cognitives, émotionnelles, sociales), **9 CPS générales** et des CPS **spécifiques**. Il insiste sur le fait que les CPS se renforcent entre elles et qu'elles s'apprennent tout au long de la vie. Une **instruction interministérielle du 19 août 2022** fixe l'objectif que toute une génération d'enfants bénéficie d'interventions de développement des CPS d'ici 2037.

Ce qui rend un programme CPS efficace

Une méta-analyse de 213 programmes scolaires de développement des compétences sociales et émotionnelles (Durlak et collaborateurs, 2011), portant sur plus de 270 000 élèves, a montré une amélioration des compétences, des comportements et même des résultats scolaires. Les programmes efficaces respectaient quatre critères, résumés par l'acronyme anglais **SAFE**.

Critère SAFE	Signification	Traduction pour une action nutrition
Sequenced (séquencé)	Des activités organisées en progression, de séance en séance	Un cycle de 8 à 10 séances, chacune s'appuyant sur la précédente, plutôt qu'une intervention isolée
Active (actif)	Des méthodes où l'on pratique	Jeux de rôle, cuisine, analyse de publicités, plutôt qu'un exposé
Focused (centré)	Un temps suffisant consacré à chaque compétence	Une ou deux CPS ciblées par séance, explicitement travaillées
Explicit (explicite)	Des objectifs de compétence clairs et annoncés	« Aujourd'hui, nous apprenons à dire non à une proposition sans vexer la personne. »

Des programmes validés utilisés en France

Programme	Public	Principe
PSFP (Programme de soutien aux familles et à la parentalité)	Familles avec enfants de 3 à 11 ans	Adaptation française d'un programme américain (*Strengthening Families Program*) : 14 séances réunissant parents et enfants, d'abord séparément puis ensemble
GBG (*Good Behavior Game*, jeu du comportement favorable)	Élèves d'école élémentaire	Jeu d'équipe en classe qui renforce les comportements favorables et l'autorégulation
Unplugged	Collégiens de 12 à 14 ans	12 séances interactives de prévention des conduites addictives, centrées sur les CPS et la correction des fausses croyances sur les normes (« tout le monde boit »)
Tina et Toni	Enfants de 4 à 6 ans	Programme d'origine suisse fondé sur des histoires et des jeux autour des émotions et des relations

Lien diététique – Place du diététicien

Ces programmes ne sont pas centrés sur l'alimentation, mais ils montrent ce qui marche : durée, interactivité, formation des intervenants. Le diététicien peut s'associer à un programme CPS existant dans une école ou un centre social, en y apportant des séances sur le goût, le marketing alimentaire ou le repas familial, plutôt que de créer une intervention isolée.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.12

Une infirmière scolaire propose au diététicien une intervention unique d'une heure en classe de 5e, sous forme d'exposé sur « les dangers du sucre », pour « développer les compétences psychosociales ». a) Montrez, à l'aide des critères SAFE, que ce projet n'est pas une action CPS. b) Proposez une version améliorée en trois séances, en indiquant pour chacune la CPS visée et une activité.

Corrigé

a) Une séance unique n'est pas **séquencée** ; un exposé n'est pas **actif** ; aucune compétence n'est ciblée (**F**) ni annoncée (**E**) : c'est une action d'information. **b)** Séance 1, **pensée critique** : analyser en groupe trois publicités pour des boissons sucrées (cible, promesse, ce qui est caché). Séance 2, **prise de décision** : composer un goûter avec un budget de 1,50 € et justifier le choix devant la classe. Séance 3, **communication constructive** : jeux de rôle « refuser une boisson énergisante proposée par un ami » et retour sur les ressentis. Chaque séance commence par l'annonce de la compétence travaillée et se termine par un temps de retour.

3.3.6 Image corporelle, émotions, estime de soi

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

Définition – Image corporelle

Représentation mentale que l'on se fait de son propre corps : perception (taille, forme), pensées et croyances, émotions qu'il suscite, et comportements qui en découlent. L'**insatisfaction corporelle** est l'écart entre le corps perçu et le corps idéal ; elle est fréquente dès l'enfance, influencée par les normes de minceur ou de muscularité diffusées par les médias et les réseaux sociaux, et constitue un **facteur de risque** de restrictions alimentaires, de régimes répétés et de troubles du comportement alimentaire (TCA).

Définition – Émotions

Réactions brèves et intenses à une situation, associant des manifestations physiologiques, des expressions et des tendances à l'action. Paul Ekman décrit six émotions de base universelles : joie, tristesse, colère, peur, dégoût, surprise. Le **dégoût** joue un rôle central dans les refus alimentaires ; la **peur** de la nouveauté dans la néophobie. L'**alimentation émotionnelle** désigne le fait de manger en réponse à des émotions plutôt qu'à la faim.

Définition – Estime de soi et confiance en soi

- L'**estime de soi** est la valeur qu'une personne s'attribue (Rosenberg, 1965) ; elle conditionne la capacité à prendre soin de soi.
- La **confiance en soi** porte sur la capacité perçue à agir ; elle est proche du **sentiment d'efficacité personnelle** de Bandura (« je suis capable de cuisiner ce plat »).

Attention – Prévenir sans nuire

- Ne jamais **peser** ni commenter le corps des participants en public.
- Éviter les messages centrés sur le **poids** et l'apparence ; centrer sur la santé, le plaisir, l'énergie, la convivialité.
- Ne pas présenter d'aliments comme « interdits » ou « mauvais » : cela renforce la culpabilité et les restrictions.
- Repérer les signes d'alerte de TCA (restriction importante, préoccupation excessive pour le poids, vomissements, hyperphagie) et **orienter** vers le médecin ou une structure spécialisée (BC1), sans poser de diagnostic.

Évaluer l'image du corps et l'estime de soi : deux outils

Dans un diagnostic ou une évaluation, on peut mesurer l'image du corps et l'estime de soi avec des outils validés. Le diététicien ne pose aucun diagnostic psychologique : il utilise ces outils pour **décrire un groupe** et adapter l'action, avec l'accord des personnes et de façon anonyme.

Définition – L'échelle des silhouettes (Stunkard, Sørensen et Schulsinger, 1983)

Neuf dessins de silhouettes, de la plus mince (1) à la plus corpulente (9). La personne indique la silhouette qui lui ressemble le plus (silhouette **perçue**) et celle qu'elle aimerait avoir (silhouette **idéale**). L'écart **perçue moins idéale** mesure l'insatisfaction : un écart positif signale un désir de minceur, un écart négatif un désir d'être plus fort ou plus musclé (fréquent chez les garçons), un écart nul l'absence d'insatisfaction.

Calcul détaillé – L'insatisfaction corporelle dans une classe de 3e (données fictives, 24 élèves)

Écart perçue − idéale	Filles (n = 12)	Garçons (n = 12)
−2	0	2
−1	1	4
0	3	4
+1	5	2
+2	3	0

- Filles insatisfaites (écart différent de 0) : 12 − 3 = 9, soit 9 / 12 = **75,0 %** ; dont désir de minceur : 5 + 3 = 8,

soit **66,7 %**.

- Garçons insatisfaits : 12 − 4 = 8, soit **66,7 %** ; dont désir d'être plus fort : 2 + 4 = 6, soit **50,0 %**.
- Écart moyen des filles : (−1 × 1 + 0 × 3 + 1 × 5 + 2 × 3) / 12 = (−1 + 0 + 5 + 6) / 12 = 10 / 12 = **+0,83**.
- Écart moyen des garçons : (−2 × 2 − 1 × 4 + 0 × 4 + 1 × 2) / 12 = (−4 − 4 + 0 + 2) / 12 = −6 / 12 = **−0,50**.

Lecture : l'insatisfaction concerne les deux sexes, mais dans des directions opposées. Une moyenne proche de zéro peut cacher des insatisfactions fortes dans les deux sens : il faut toujours regarder la **répartition**. Les actions porteront sur la diversité des corps et la critique des images des réseaux sociaux, pour les filles comme pour les garçons, sans parler de poids.

Définition – L'échelle d'estime de soi de Rosenberg (1965)

Dix affirmations, cotées de 1 (« tout à fait en désaccord ») à 4 (« tout à fait en accord »). Cinq affirmations sont positives (« Je pense que je possède un certain nombre de belles qualités ») et cinq négatives (« J'aimerais avoir plus de respect pour moi-même »). Les affirmations négatives sont **inversées** (score inversé = 5 − réponse). Le score total va de **10 à 40** : plus il est élevé, plus l'estime de soi est forte. L'échelle existe en version française validée (Vallières et Vallerand, 1990).

Calcul détaillé – Le score d'estime de soi de Lina, 15 ans

Réponses aux 5 items positifs : 3, 2, 3, 2, 3 ; total = **13**.

Réponses aux 5 items négatifs : 3, 4, 2, 3, 3 ; scores inversés : 5 − 3 = 2 ; 5 − 4 = 1 ; 5 − 2 = 3 ; 5 − 3 = 2 ; 5 − 3 = 2 ; total = **10**.

Score total : 13 + 10 = **23 sur 40**, soit, ramené sur 100 : (23 − 10) / (40 − 10) × 100 = 13 / 30 × 100 = **43 / 100**.

Lecture : estime de soi plutôt basse. Le score ne sert pas à « étiqueter » Lina : il aide l'équipe à prévoir des activités valorisantes. Un score très bas associé à d'autres signes (isolement, restriction alimentaire) justifie d'en parler à l'infirmière ou au psychologue scolaire.

Repérer les signaux d'alerte de troubles du comportement alimentaire

Méthode pas à pas – Le questionnaire SCOFF-F

Le questionnaire SCOFF (Morgan et collaborateurs, 1999), validé en français sous le nom de SCOFF-F, est cité par la HAS (recommandation sur l'anorexie mentale, 2010) comme outil de **repérage**. Il comporte cinq questions fermées :

1. Vous faites-vous vomir parce que vous vous sentez mal d'avoir trop mangé ?
2. Vous inquiétez-vous d'avoir perdu le contrôle de ce que vous mangez ?
3. Avez-vous récemment perdu plus de 6 kg en 3 mois ?
4. Pensez-vous que vous êtes gros(se) alors que d'autres vous trouvent trop mince ?
5. Diriez-vous que la nourriture domine votre vie ?

Deux réponses positives ou plus font suspecter un TCA. Le repérage est suivi d'une **orientation** vers le médecin traitant ou une structure spécialisée ; il ne s'agit jamais d'un diagnostic.

Attention – En action collective

On ne fait pas remplir de questionnaire de repérage des TCA dans un atelier collectif sans cadre médical, sans information des personnes et sans circuit d'orientation prévu. En action collective, le diététicien observe, écoute et oriente individuellement et discrètement si une personne l'inquiète.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.13

Dans un groupe de 10 lycéennes, les écarts silhouette perçue moins silhouette idéale sont : +2, +1, 0, +3, +1, +2, 0, +1, +2, +1. a) Calculez le pourcentage de jeunes filles qui souhaitent être plus minces et l'écart moyen. b) Une élève (écart +3) dit qu'elle saute le dîner depuis deux mois. Que faites-vous ? c) Proposez un thème d'atelier adapté au groupe.

Corrigé

a) Écarts positifs : 8 sur 10, soit **80 %**. Écart moyen : (2 + 1 + 0 + 3 + 1 + 2 + 0 + 1 + 2 + 1) / 10 = 13 / 10 = **+1,3**. **b)** Écouter sans juger, ne pas commenter son poids, lui dire que l'on s'inquiète pour elle et l'**orienter** vers l'infirmière scolaire ou le médecin, en respectant la confidentialité ; prévenir l'infirmière selon les règles de l'établissement. **c)** Un atelier sur les images retouchées et les réseaux sociaux (pensée critique), suivi d'un atelier « petit-déjeuner et énergie » centré sur le plaisir et la performance scolaire, sans aucune référence au poids.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 3.3.5 et 3.3.6 – Compétences psychosociales, image du corps, estime de soi

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les trois catégories de CPS du référentiel de Santé publique France (2022) et le nombre de CPS générales.
2. Que signifie l'acronyme SAFE ?
3. Comment calcule-t-on l'insatisfaction corporelle avec l'échelle de Stunkard ?
4. Quelle est l'étendue du score de l'échelle de Rosenberg ? Comment traite-t-on les items négatifs ?
5. Combien de réponses positives au SCOFF-F font suspecter un TCA ? Que fait-on ensuite ?
6. Citez deux règles pour « prévenir sans nuire » en atelier.

Corrigé – Point d'étape 3.3.5 et 3.3.6

1. Cognitives, émotionnelles, sociales ; 9 CPS générales (3 par catégorie).
2. Séquencé, actif, centré, explicite (*Sequenced*, *Active*, *Focused*, *Explicit*) : critères des programmes efficaces (Durlak, 2011).
3. Silhouette perçue moins silhouette idéale : un écart positif traduit un désir de minceur, un écart négatif un désir d'être plus fort.
4. De 10 à 40 ; les items négatifs sont inversés (5 − réponse) avant l'addition.
5. Deux ou plus ; on oriente vers le médecin ou une structure spécialisée, sans poser de diagnostic.
6. Ne jamais peser ni commenter le corps en public ; centrer sur la santé, le plaisir et la convivialité ; ne pas parler d'aliments interdits ; repérer et orienter.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

3.3.7 Connaître les publics et comprendre le changement de comportement

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M5 S2 §3 (p. 38 et 39)

Les spécificités des publics

Public	Caractéristiques	Adaptations de l'action
Jeunes enfants (2-6 ans)	Néophobie alimentaire maximale ; apprentissage par l'imitation et l'exposition répétée ; pensée concrète	Jeux sensoriels, manipulations, expositions répétées sans forcer, implication des parents
Enfants (6-11 ans)	Curiosité, goût du défi, influence de l'école et des pairs, sensibilité à la publicité	Ateliers pratiques, quiz, défis, classes du goût, projets de classe
Adolescents	Construction de l'identité, influence des pairs et des réseaux, autonomie, préoccupations corporelles	Pairs ambassadeurs, débats, réseaux sociaux, respect de l'autonomie, prévention de la stigmatisation
Adultes	Contraintes (temps, budget, travail), habitudes installées, rôle de « nourricier » pour la famille	Solutions concrètes et rapides, partage d'expériences, valorisation des savoir-faire
Personnes âgées	Baisse de l'appétit et du goût, isolement, troubles de la mastication, habitudes anciennes, peur de la maladie	Convivialité, repas partagés, textures adaptées, réminiscence, rythme lent, gros caractères
Personnes en précarité	Contraintes budgétaires, stress, parfois honte, défiance envers les institutions	Gratuité, non-jugement, valorisation des compétences, recettes à petit prix
Personnes allophones ou migrantes	Langue, codes culturels, produits inconnus, parcours parfois traumatique	Interprétariat, supports visuels, recettes du pays, posture interculturelle
Personnes en situation de handicap	Besoins variables (moteurs, sensoriels, cognitifs, psychiques)	FALC, matériel adapté, pictogrammes, rythme individualisé, accessibilité des locaux

Les modèles du changement de comportement

Définition – Modèle des croyances relatives à la santé (Health Belief Model, Rosenstock, Becker, années 1950-1970)

Une personne adopte un comportement de santé si elle se perçoit **vulnérable** au problème, si elle le juge **grave**, si elle perçoit des **bénéfices** supérieurs aux **obstacles**, en présence d'un **déclencheur** (incitation à l'action) et avec un sentiment d'**efficacité personnelle**.

Composante du modèle des croyances relatives à la santé	Question que se pose la personne	Exemple : dépistage du diabète chez des adultes de 50 ans	Levier pour l'action
Vulnérabilité perçue	« Est-ce que cela peut m'arriver ? »	« Le diabète, c'est pour les gros, pas pour moi. »	Présenter les facteurs de risque concrets (âge, antécédents familiaux, sédentarité)
Gravité perçue	« Est-ce grave si cela m'arrive ? »	« Un peu de sucre dans le sang, ce n'est rien. »	Témoignage d'un pair sur les complications évitées grâce à un repérage précoce
Bénéfices perçus	« Qu'est-ce que j'y gagne ? »	« Savoir tôt permet d'agir par l'alimentation. »	Montrer ce qui change concrètement après un dépistage
Obstacles perçus	« Qu'est-ce que cela me coûte ? »	Peur de la piqûre, temps, déplacement	Test capillaire gratuit sur le marché, sans rendez-vous
Incitation à l'action	« Qu'est-ce qui me décide maintenant ? »	Courrier, conseil du médecin, stand en pharmacie	Rappel par SMS, présence d'un stand lors d'un événement
Efficacité personnelle (ajoutée en 1988)	« Suis-je capable de le faire ? »	« Je ne saurai pas changer mon alimentation. »	Atelier culinaire, petits objectifs réalisables

Attention – Les limites du modèle

Le modèle des croyances relatives à la santé décrit une personne **rationnelle** qui pèse le pour et le contre. Il prédit mal les comportements **habituels** et automatiques (grignoter, boire un soda), et il donne peu de place aux **normes sociales** et aux émotions. Il est surtout utile pour des comportements ponctuels et délibérés : se faire dépister, se faire vacciner, consulter.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.14

Un centre de santé constate que peu de femmes enceintes du quartier participent à l'atelier gratuit « bien manger pendant la grossesse ». Voici ce qu'elles disent : « J'ai déjà eu deux enfants, je sais faire » ; « Le diabète de grossesse, ma cousine l'a eu, ce n'était pas grave » ; « L'atelier est à 9 h, je dépose les enfants à l'école » ; « Si la sage-femme me le conseillait, j'irais ». a) Associez chaque phrase à une composante du modèle. b) Proposez une action pour chacune.

Corrigé

a) « Je sais faire » : **vulnérabilité perçue** faible (« cela ne me concerne pas ») et confiance élevée ; « ce n'était pas grave » : **gravité perçue** faible ; « l'atelier est à 9 h » : **obstacle perçu** ; « si la sage-femme me le conseillait » : **incitation à l'action**. **b)** Valoriser l'expérience des mères (elles peuvent témoigner et aider les autres) tout en présentant ce qui est nouveau à chaque grossesse ; inviter une mère ou une sage-femme à expliquer simplement les conséquences du diabète gestationnel pour la mère et le bébé, sans dramatiser ; déplacer l'atelier à 10 h ou proposer une garde d'enfants ; demander aux sages-femmes de remettre une invitation personnalisée en consultation.

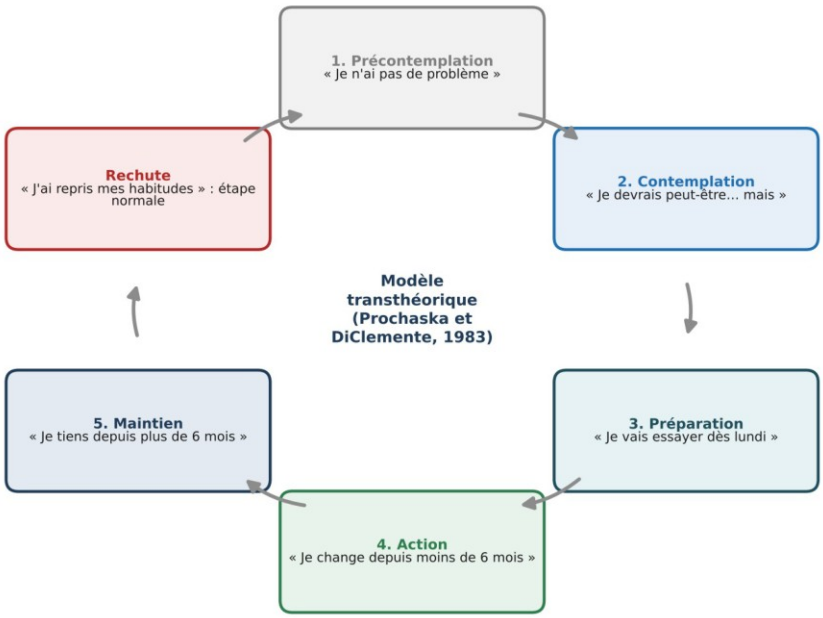


Figure 3.4 – Les étapes du changement selon Prochaska et DiClemente (1983)

Comprendre le schéma – Figure 3.4

1. Précontemplation : la personne n'envisage pas de changer (« je n'ai pas de problème ») ; objectif : informer sans braquer, susciter la réflexion.

2. Contemplation : elle envisage le changement mais reste ambivalente (« je devrais, mais… ») ; objectif : explorer les avantages et les inconvénients (balance décisionnelle).

3. Préparation : elle prévoit d'agir à court terme ; objectif : aider à fixer un objectif concret et réaliste.

4. Action : elle a changé depuis moins de 6 mois ; objectif : soutenir, valoriser, aider à surmonter les obstacles.

5. Maintien : le changement dure depuis plus de 6 mois ; objectif : prévenir la rechute.

6. Rechute : retour aux anciennes habitudes, considéré comme une étape **normale** du processus, qui permet d'apprendre ; on repart dans le cycle.

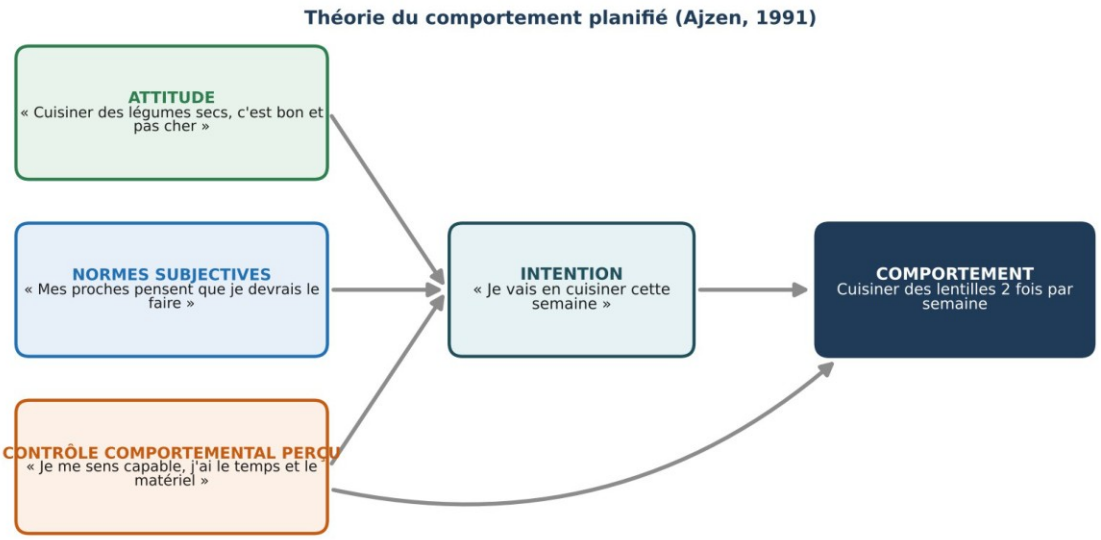


Figure 3.5 – La théorie du comportement planifié (Ajzen, 1991), appliquée aux légumes secs

Comprendre le schéma – Figure 3.5

1. L'**attitude** : ce que la personne pense du comportement (positif ou négatif).
2. Les **normes subjectives** : ce qu'elle pense que ses proches attendent d'elle.
3. Le **contrôle comportemental perçu** : sa capacité perçue à réaliser le comportement (temps, argent, compétences).
4. Ces trois éléments déterminent l'**intention**, qui précède le **comportement**.
5. Le contrôle perçu agit aussi **directement** sur le comportement (flèche courbe) : même avec une bonne intention, sans compétences ni moyens, le comportement n'a pas lieu. D'où l'intérêt de faire **cuisiner** en atelier.

Définition – Sentiment d'efficacité personnelle (Albert Bandura, 1977)

Croyance d'une personne en sa capacité à réaliser une action précise. Il se développe par quatre sources : les **expériences de réussite** personnelles (la plus puissante), l'**observation** de pairs qui réussissent (apprentissage vicariant), la **persuasion** verbale (encouragements), et l'état **physiologique et émotionnel** (se sentir détendu).

Lien diététique – L'entretien motivationnel (lien BC1)

Développé par William Miller et Stephen Rollnick (1983, 2013), l'entretien motivationnel est une méthode de communication centrée sur la personne qui vise à **renforcer sa motivation propre** au changement en explorant son **ambivalence**. Ses outils (questions ouvertes, valorisation, reflets, résumés) sont utiles aussi en animation de groupe. Il est approfondi dans le BC1.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.15

Identifiez l'étape du changement et proposez une réponse adaptée : a) « Les légumes, chez nous, personne n'aime, et on n'a jamais été malades. » b) « J'aimerais bien cuisiner plus, mais je n'ai jamais le temps. » c) « Depuis l'atelier, je fais des lentilles tous les lundis, ça fait deux mois. » d) « J'avais arrêté les sodas, mais avec les vacances j'ai repris. »

Corrigé

a) Précontemplation : ne pas argumenter de front ; poser une question ouverte (« qu'est-ce que vous aimez cuisiner ? »), proposer de goûter sans engagement. **b) Contemplation** : explorer l'ambivalence (« qu'est-ce qui vous donnerait envie ? qu'est-ce qui bloque ? ») ; proposer des recettes en 15 minutes. **c) Action** (moins de 6 mois) : valoriser, féliciter, aider à varier pour maintenir la motivation. **d) Rechute** : la dédramatiser (étape normale), analyser la situation déclenchante, aider à reprendre un objectif réaliste.

Intégration, pauvreté, exclusion : le vocabulaire de la sociologie

Notion	Définition simple	Auteur repère
Intégration	Façon dont les personnes sont reliées entre elles et à la société	Durkheim (*De la division du travail social*, 1893)
Lien social	Ensemble des liens familiaux, sociaux, culturels et économiques qui assurent la cohésion de la société ; il découle de la socialisation	Durkheim ; Serge Paugam
Exclusion sociale	Cumul de difficultés (chômage durable, rupture familiale, perte du logement) qui éloigne la personne de la vie sociale	René Lenoir (*Les Exclus*, 1974)
Disqualification sociale	Affaiblissement puis rupture des liens, avec perte de protection et de reconnaissance ; trois phases : fragilité, dépendance aux aides, rupture	Serge Paugam (1991)
Désaffiliation	Suite de décrochages (travail, famille, entourage) ; trois zones : intégration, vulnérabilité, désaffiliation	Robert Castel (1995)
Classes sociales	Groupes définis par leur place dans la production ; conscience de classe et conflit	Karl Marx
Stratification	Hiérarchie de positions (richesse, prestige, pouvoir) sans frontière nette entre les strates	Max Weber
Capitaux	Capital **économique** (revenus, patrimoine), **culturel** (diplômes, savoirs), **social** (relations), qui expliquent les goûts et les pratiques	Pierre Bourdieu (1979)

Définition – Pauvreté monétaire (Insee)

Une personne est **pauvre** au sens monétaire quand son **niveau de vie** est inférieur à **60 % du niveau de vie médian**. C'est une pauvreté **relative** : elle mesure l'écart avec le reste de la population, et non l'impossibilité de survivre. Le niveau de vie est le revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'**unités de consommation** (UC) : 1 UC pour le premier adulte, 0,5 pour chaque autre personne de 14 ans ou plus, 0,3 pour chaque enfant de moins de 14 ans.

À retenir – Les chiffres en vigueur (Insee, publication du 9 juillet 2026)

En **2024**, le seuil de pauvreté à 60 % est de **1 337 € par mois** pour une personne seule. Le taux de pauvreté atteint **15,4 %** de la population (France métropolitaine), soit **9,8 millions** de personnes.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.16

Un couple avec deux enfants de 6 et 10 ans dispose d'un revenu disponible de 2 600 € par mois. a) Calculez le nombre d'UC et le niveau de vie mensuel. b) Ce ménage est-il sous le seuil de pauvreté de 2024 ? c) Quel revenu lui faudrait-il pour atteindre ce seuil ?

Corrigé

a) UC = 1 + 0,5 + 0,3 + 0,3 = **2,1** ; niveau de vie = 2 600 / 2,1 = **1 238 €** par mois. b) Oui : 1 238 € < 1 337 €. c) 1 337 × 2,1 = **2 808 €** par mois (2 807,70 €), soit 208 € de plus. Pour l'atelier, cela oriente vers des menus à petit budget, l'aide alimentaire et l'épicerie solidaire, sans stigmatiser la famille.

Entre l'intention et le comportement : un écart

Les modèles d'Ajzen et de Prochaska accordent une place centrale à l'**intention**. Or vouloir ne suffit pas. Une synthèse de méta-analyses (Sheeran, 2002) estime que l'intention n'explique qu'environ **28 %** des différences de comportement entre les personnes. Une autre méta-analyse d'études expérimentales (Webb et Sheeran, 2006) montre qu'un changement important de l'intention ne produit qu'un changement **petit à moyen** du comportement. C'est l'**écart intention-comportement** : beaucoup de personnes qui veulent manger plus de légumes n'y arrivent pas.

Cause de l'écart	Exemple	Ce qui aide
Oublier d'agir au bon moment	« J'avais prévu de prendre des fruits, mais j'ai oublié en faisant les courses. »	Une liste de courses, un rappel, une intention de mise en œuvre
Ne pas savoir par où commencer	« Je veux cuisiner plus, mais quoi ? »	Un objectif précis et une recette simple
Se laisser détourner par une tentation	Le distributeur de la salle de pause	Modifier l'environnement, prévoir une collation
Retomber dans une habitude	Le soda pris automatiquement en rentrant	Remplacer l'habitude par une autre, déclenchée par le même signal

Définition – Les intentions de mise en œuvre (Gollwitzer, 1999)

Une **intention de mise en œuvre** est un plan de la forme **« Si (situation), alors (action) »** : « Si je fais les courses le samedi, alors je prends un sachet de lentilles corail » ; « Si j'ai envie de grignoter devant la télévision, alors je me sers un verre d'eau et une pomme ». Elle relie un signal précis à une action, ce qui rend l'action plus automatique. Une méta-analyse de 94 études (Gollwitzer et Sheeran, 2006) a montré un effet **moyen à fort** de cette technique sur l'atteinte des objectifs.

Définition – Habitude

Une **habitude** est un comportement déclenché **automatiquement** par un signal du contexte (un lieu, une heure, une personne, une émotion), sans réflexion, parce qu'il a été répété souvent dans ce contexte. Une grande partie de l'alimentation quotidienne est faite d'habitudes : elles relèvent de la **motivation automatique** du modèle COM-B (section 3.3.13).

Exemple – Combien de temps faut-il pour créer une habitude ? (Lally et collaborateurs, 2010)

Quatre-vingt-seize volontaires londoniens ont choisi un nouveau comportement de santé à réaliser chaque jour dans le même contexte (par exemple manger un fruit au déjeuner). Ils ont noté chaque jour à quel point l'action leur paraissait automatique. Le temps pour atteindre 95 % du plateau d'automaticité était de **66 jours**

en valeur médiane, avec une très grande variation selon les personnes et les comportements (de **18 à 254 jours**). Oublier une journée n'empêchait pas l'habitude de se former.

Leçons : l'idée répandue qu'« il faut 21 jours pour créer une habitude » n'a pas de base solide ; il faut plutôt compter **plusieurs semaines à plusieurs mois** ; un écart ponctuel n'est pas un échec. Un cycle d'ateliers doit donc prévoir un suivi après la dernière séance.

Méthode pas à pas – Aider un groupe à passer de l'intention à l'action

1. Faire choisir à chacun **un seul** objectif précis et réaliste (« deux fois par semaine, un plat avec des légumes secs »).
2. Faire écrire une intention de mise en œuvre : « Si…, alors… ».
3. Repérer à l'avance un **obstacle** probable et sa solution (« Si je rentre trop tard, alors je réchauffe les lentilles cuisinées la veille »).
4. Attacher le nouveau comportement à une habitude existante (après le café du matin, au retour des courses).
5. Prévoir un **suivi** : retour à la séance suivante, message de rappel, carnet de suivi.
6. Dédramatiser les écarts : l'habitude se construit sur la répétition, pas sur la perfection.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.17

À la fin d'un atelier, M. K., chauffeur routier, déclare : « Il faut vraiment que je mange mieux. » Il prend souvent un sandwich et un soda à la station-service. a) Pourquoi cette intention risque-t-elle de ne pas se traduire en comportement ? b) Aidez-le à formuler deux intentions de mise en œuvre. c) Combien de temps faut-il prévoir avant que le nouveau comportement devienne automatique ?

Corrigé

a) L'intention est **vague** (que signifie « mieux » ?), aucun moment ni action précise n'est prévu, et le comportement actuel est une **habitude** déclenchée par un contexte fort (la pause à la station). **b)** « Si je m'arrête à la station-service, alors je prends une bouteille d'eau à la place du soda » ; « Si je pars le matin, alors je mets dans ma glacière une boîte de taboulé préparée la veille et un fruit ». **c)** Plusieurs semaines à plusieurs mois : 66 jours en valeur médiane dans l'étude de Lally (2010), avec de fortes différences d'une personne à l'autre. Un oubli ponctuel n'est pas grave.

Renforcer le sentiment d'efficacité personnelle en atelier

Le sentiment d'efficacité personnelle (Bandura, 1977) est l'une des variables les plus liées au changement durable. Il ne se décrète pas : il se construit à partir de ses **quatre sources**.

Source (de la plus forte à la plus faible)	Mécanisme	Application concrète en atelier culinaire
Expériences de réussite	« Je l'ai fait, donc je peux le refaire. »	Chaque participant réalise lui-même une étape ; recette simple au début, difficulté progressive ; on repart avec son plat
Expériences vicariantes (observation)	« Quelqu'un comme moi y arrive, donc moi aussi. »	Démonstration par un pair plutôt que par un chef ; témoignage d'un participant des cycles précédents
Persuasion verbale	« On me dit que j'en suis capable. »	Encouragements précis et sincères (« votre découpe est régulière ») plutôt que des compliments vagues

Source (de la plus forte à la plus faible)	Mécanisme	Application concrète en atelier culinaire
États physiologiques et émotionnels	« Je me sens détendu, donc capable. »	Accueil chaleureux, pas de chronomètre, droit à l'erreur, ambiance détendue

Définition – Mesurer l'efficacité personnelle

Le sentiment d'efficacité personnelle se mesure soit de façon **spécifique** à un comportement (« Je me sens capable de cuisiner un plat de légumes secs en moins de 30 minutes », de 1 à 5), ce qui est le plus pertinent pour évaluer un atelier, soit de façon **générale**. L'échelle d'auto-efficacité générale de Schwarzer et Jerusalem (1995), traduite en français, comporte **10 items** notés de 1 (« pas du tout vrai ») à 4 (« totalement vrai ») ; le score va de **10 à 40**.

Calcul détaillé – Le score de Mme A. à l'échelle générale

Réponses aux 10 items : 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2.

- Score total : 2 + 3 + 2 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 + 2 + 2 = **22 sur 40**.
- Position sur l'étendue : (22 − 10) / (40 − 10) × 100 = 12 / 30 × 100 = **40 / 100**.

Lecture : sentiment d'efficacité générale plutôt bas. Pour évaluer l'effet d'un atelier, on préfère une question **spécifique** au comportement travaillé, posée avant et après, car l'efficacité générale évolue lentement.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.18

M. D., 68 ans, veuf depuis un an, dit : « C'est ma femme qui faisait la cuisine, moi je ne sais rien faire, je mange des plats tout prêts. » a) Quelle variable psychosociale est en jeu ? b) Proposez une action pour chacune des quatre sources. c) Rédigez une question pour mesurer l'effet de l'atelier sur cette variable.

Corrigé

a) Un faible **sentiment d'efficacité personnelle** pour cuisiner (« je ne sais rien faire »), dans un contexte de deuil et de rupture des rôles. **b) Réussite** : lui faire préparer seul une omelette aux légumes, puis une soupe, en augmentant progressivement la difficulté. **Observation** : le faire cuisiner aux côtés d'un autre homme âgé qui a appris récemment. **Persuasion** : encouragements précis (« vos légumes sont bien coupés, la cuisson est parfaite »). **État émotionnel** : petit groupe, ambiance conviviale, aucune pression de temps ; prendre en compte le deuil (écoute, orientation si besoin). **c)** « Je me sens capable de préparer un repas simple et complet pour moi le soir », de 1 (« pas du tout ») à 5 (« tout à fait »), posée au premier et au dernier atelier.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 3.3.7 – Connaître les publics et comprendre le changement

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les composantes du modèle des croyances relatives à la santé.
2. Pour quel type de comportement ce modèle est-il le plus utile ? Pourquoi ?
3. Nommez les six étapes de Prochaska et DiClemente et donnez la durée qui sépare action et maintien.
4. Quels sont les trois déterminants de l'intention selon Ajzen ? Lequel agit aussi directement sur le comportement ?
5. Qu'est-ce qu'une intention de mise en œuvre ? Donnez un exemple.
6. Combien de temps faut-il pour qu'une habitude devienne automatique selon Lally (2010) ?

Corrigé – Point d'étape 3.3.7

1. Vulnérabilité perçue, gravité perçue, bénéfices perçus, obstacles perçus, incitation à l'action, efficacité personnelle.
2. Les comportements ponctuels et délibérés (dépistage, vaccination), car il décrit une décision rationnelle et prend peu en compte les habitudes et les normes.
3. Précontemplation, contemplation, préparation, action, maintien, rechute ; 6 mois.
4. L'attitude, la norme subjective et le contrôle comportemental perçu ; c'est le contrôle perçu qui agit aussi directement.
5. Un plan « si (situation), alors (action) » : « Si je fais les courses le samedi, alors je prends des lentilles » (Gollwitzer, 1999).
6. 66 jours en valeur médiane, avec une grande variation (de 18 à 254 jours).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

3.3.8 Communiquer et écouter : les bases de la relation éducative

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · CNED : Synthèse M5 S2 §2 (p. 36 à 38)

La communication interpersonnelle

Communiquer, ce n'est pas seulement transmettre une information : c'est établir une **relation**. L'école de **Palo Alto** (Watzlawick, Beavin et Jackson, *Une logique de la communication*, 1967) a formulé plusieurs principes devenus classiques, dont deux sont essentiels en éducation pour la santé : « **on ne peut pas ne pas communiquer** » (un silence, un regard, une posture disent quelque chose) et « toute communication comporte un **contenu** et une **relation** » (la même phrase peut être reçue comme un conseil ou comme un jugement selon le ton et la relation).

Composante	Exemples en atelier
Verbale	Choix des mots (« légumes secs » plutôt que « légumineuses »), clarté, phrases courtes (chapitre 5)
Paraverbale	Ton, débit, volume, silences ; un ton enjoué et posé rassure
Non verbale	Regard, sourire, posture ouverte, gestes, distance ; se placer à hauteur des personnes assises ; éviter les bras croisés
Contexte	Lieu, disposition de la salle (cercle plutôt que rangées), horaires, présence d'enfants

Attention – La « règle des 7 %, 38 %, 55 % » : un mythe

On lit souvent que 93 % de la communication serait non verbale. Ces chiffres viennent d'expériences d'Albert Mehrabian (1967) portant sur des mots isolés exprimant des **sentiments**, quand le ton et le visage contredisaient le mot ; ils ne s'appliquent pas à la communication en général. Retenez seulement que le non-verbal **renforce ou contredit** le message verbal, et qu'en cas de contradiction, c'est souvent lui que l'on croit.

L'écoute active

Définition – Écoute active (Carl Rogers)

Attitude d'écoute centrée sur la personne, fondée sur trois conditions décrites par le psychologue Carl **Rogers**

(années 1950-1960) : l'**empathie** (comprendre le point de vue de l'autre de l'intérieur, sans le partager forcément), l'**acceptation inconditionnelle** (accueillir la personne sans la juger) et la **congruence** (être authentique, en accord entre ce que l'on ressent et ce que l'on exprime). Elle s'appuie sur des techniques : questions ouvertes, reformulation, silences, synthèse.

Technique	Définition	Exemple
Question ouverte	Question qui ne se répond pas par oui ou non	« Comment se passent les repas à la maison ? »
Reformulation simple	Redire avec d'autres mots ce que la personne a dit	« Si je comprends bien, le soir vous manquez de temps. »
Reformulation reflet	Exprimer le sentiment perçu	« Ça a l'air de vous inquiéter que votre fils ne mange pas de légumes. »
Silence	Laisser un temps après une question ou une confidence	(attendre 3 à 5 secondes)
Valorisation	Reconnaître un effort, une compétence	« Vous avez déjà trouvé une astuce avec la soupe, c'est intéressant. »
Synthèse	Résumer les points importants	« Nous avons parlé du budget, du temps et des goûts des enfants. »

Attention – Les attitudes spontanées qui bloquent l'échange (Porter, 1950)

Le psychologue Elias Porter a décrit six attitudes : **évaluation** (juger : « Ce n'est pas bien de donner des sodas »), **interprétation** (« Vous dites ça parce que vous êtes fatiguée »), **soutien** (consoler, minimiser : « Ce n'est pas grave »), **enquête** (questions en rafale), **solution** (donner tout de suite un conseil) et **compréhension** (reformuler). Seule la **compréhension** favorise l'expression ; les autres sont parfois utiles, mais, utilisées d'emblée, elles ferment le dialogue. Le diététicien a souvent le réflexe de la « solution » : il gagne à écouter et reformuler d'abord.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.19

Une mère dit en atelier : « De toute façon, mes enfants ne mangent que des pâtes, j'ai tout essayé. » Proposez une réponse pour chaque attitude de Porter et indiquez laquelle choisir.

Corrigé

Évaluation : « Il faut quand même varier. » Interprétation : « Vous avez peut-être abandonné trop vite. » Soutien : « Ne vous inquiétez pas, c'est normal. » Enquête : « Depuis quand ? Quels légumes ? Combien de fois ? » Solution : « Mettez des légumes dans les pâtes. » **Compréhension** : « Vous avez l'impression d'avoir tout essayé et c'est décourageant. » C'est la compréhension qu'on choisit d'abord ; une fois que la personne se sent entendue, on peut explorer (« Qu'est-ce qui a marché, même un peu ? ») puis proposer des pistes avec elle.

Le schéma de la communication et ses obstacles

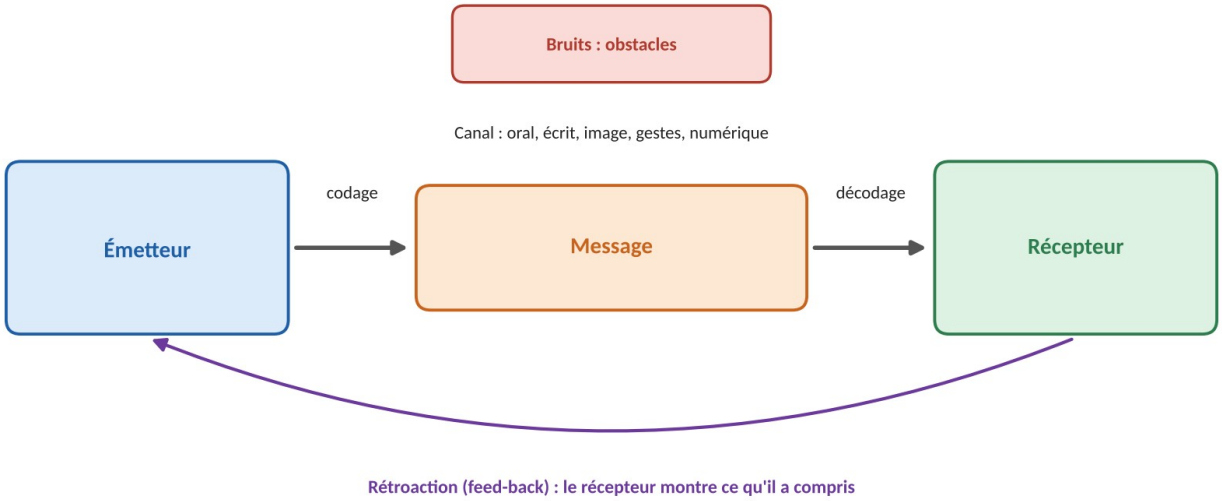


Figure 3.5 bis – Le schéma de la communication interpersonnelle

Comprendre le schéma – Figure 3.5 bis

1. L'**émetteur** a une idée qu'il **code** en mots, en images ou en gestes ; ce code forme le **message**.
2. Le message passe par un **canal** : la voix, un écrit, une image, un geste, un écran.
3. Le **récepteur décode** le message avec ses propres connaissances, sa langue, sa culture et ses émotions : ce qu'il comprend n'est jamais exactement ce que l'émetteur voulait dire.
4. Des **bruits** gênent la transmission à chaque étape.
5. La **rétroaction** (le *feed-back*) permet de vérifier ce qui a été compris et de corriger. Ce schéma vient du modèle technique de Shannon et Weaver (1949), complété par les apports de la psychologie : sans rétroaction, on informe, on ne communique pas.

Type de bruit	Exemples en atelier ou en consultation collective	Comment le réduire
Physique	Bruit de la hotte, salle mal éclairée, masque qui cache la bouche	Couper les appareils pendant les consignes, se placer face au groupe, parler plus lentement
Linguistique	Mots techniques (« glucides complexes », « densité énergétique »), langue étrangère	Mots simples, images, aliments réels, interprète professionnel (chapitre 5)
Culturel	Le geste « pouce levé » ou le contact visuel n'ont pas le même sens partout ; « léger » ne veut pas dire la même chose pour tous	Demander, observer, ne pas supposer
Psychologique	Fatigue, inquiétude pour un enfant, sentiment d'être jugé, préjugés envers le professionnel	Accueil chaleureux, non-jugement, pause
Sensoriel ou cognitif	Baisse d'audition, de vision, troubles de la mémoire	Gros caractères, supports visuels, répétition, phrases courtes

Vérifier la compréhension : la méthode « dites-le-moi avec vos mots »

Définition – Teach-back (« dites-le-moi avec vos mots »)

Méthode qui consiste à demander à la personne de **réexpliquer avec ses propres mots** ce qu'elle a compris, puis à reformuler et compléter si besoin. Elle est recommandée pour les personnes ayant une faible littératie en santé (chapitre 5), mais elle est utile avec tous les publics. La responsabilité de la compréhension est

portée par le professionnel : on ne demande pas « Avez-vous compris ? » (presque tout le monde répond oui), mais « Pour être sûr d'avoir été clair, pouvez-vous me dire comment vous allez préparer les lentilles ce soir ? ».

Méthode pas à pas – Utiliser le teach-back en groupe

1. Donner **deux ou trois messages** au maximum, avec un support concret (l'aliment, l'emballage, une photo).
2. Demander à un volontaire, ou à un binôme, de réexpliquer à un autre participant : « Comment expliqueriez-vous à votre voisine de palier comment faire tremper les pois chiches ? »
3. Écouter sans corriger tout de suite ; repérer ce qui manque ou ce qui est faux.
4. Réexpliquer autrement le point mal compris (autre mot, autre image, démonstration).
5. Vérifier de nouveau.
6. Remercier : la personne a aidé le groupe, et vous a aidé à mieux expliquer.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.20

Dans un atelier en EHPAD, une diététicienne présente l'enrichissement des purées pendant que l'aide-cuisinière utilise un mixeur. À la fin, elle demande « Tout le monde a compris ? » et plusieurs résidents hochent la tête. Le lendemain, aucun n'a demandé de fromage râpé sur sa purée. a) Repérez trois bruits dans cette situation. b) Pourquoi la question finale ne permettait-elle pas de vérifier la compréhension ? c) Réécrivez la fin de l'atelier.

Corrigé

a) Bruit **physique** (le mixeur couvre la voix) ; bruit **sensoriel** probable (baisse d'audition fréquente chez les résidents) ; bruit **linguistique** possible (« enrichissement » est un mot technique) ; on peut aussi penser à un bruit **psychologique** (gêne de demander un supplément). **b)** C'est une question fermée qui appelle un « oui » de politesse ; elle ne donne aucune **rétroaction** sur ce qui a été compris. **c)** Couper le mixeur, montrer un bol de purée et le fromage râpé, puis demander : « Imaginons que vous êtes au repas de midi : qu'allez-vous demander au serveur pour votre purée ? » ; reformuler la réponse, répéter le message en une phrase simple et laisser une petite carte illustrée sur la table.

3.3.9 L'esprit de l'entretien motivationnel appliqué au collectif

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

L'**entretien motivationnel** (Miller et Rollnick, 1983, puis 2013 pour la 3e édition) est un style de conversation collaboratif qui vise à renforcer la **motivation propre** d'une personne au changement, en explorant et en résolvant son **ambivalence**. Développé pour les addictions, il est très utilisé en nutrition (BC1). Ses principes inspirent aussi l'animation de groupes en santé publique.

Principe	Traduction
Esprit	Partenariat (pas d'expert qui sait tout), acceptation (respect de l'autonomie), compassion (agir pour le bien de la personne), évocation (faire émerger les raisons de la personne plutôt que d'imposer les siennes)
Ambivalence	La personne veut et ne veut pas changer en même temps (« Je voudrais cuisiner plus, mais je n'ai pas le temps ») : c'est normal, on l'explore sans la combattre
Réflexe correcteur	Tendance du professionnel à argumenter pour le changement ; elle provoque souvent la résistance (« Oui, mais… ») : il faut la freiner

Principe	Traduction
Discours-changement	Phrases où la personne exprime son désir, sa capacité, ses raisons, son besoin, puis son engagement à changer ; le professionnel les repère et les renforce

Méthode pas à pas – Les quatre savoir-faire de base (OuVER)

- **Questions Ouvertes** : « Qu'est-ce qui serait le plus facile à changer pour vous ? »
- **Valorisation** : souligner les forces et les efforts.
- **Écoute réflective** (reflets) : reformuler, refléter les sentiments et le discours-changement.
- **Résumés** : rassembler les éléments, en particulier les raisons de changer.

En anglais, l'acronyme est **OARS** (*Open questions*, *Affirmations*, *Reflections*, *Summaries*).

La balance décisionnelle

Exemple – Calcul détaillé : une balance décisionnelle pondérée

Un participant hésite à préparer lui-même ses déjeuners au travail. On lui demande de lister avantages et inconvénients du changement et de noter leur importance de 1 (faible) à 5 (forte).

Élément	Note	Côté
Économiser de l'argent (environ 5 € par jour)	5	Pour
Manger plus de légumes	3	Pour
Mieux digérer l'après-midi	2	Pour
Temps de préparation le soir	4	Contre
Moqueries possibles des collègues	2	Contre
Pas de micro-ondes au travail	3	Contre

- Total « pour » : 5 + 3 + 2 = **10** ; total « contre » : 4 + 2 + 3 = **9**.
- Écart : 10 − 9 = **1** : la balance est presque équilibrée, signe d'**ambivalence** ; ce n'est pas le moment de « pousser », mais d'explorer.
- **Piste** : agir sur les inconvénients modifiables (« contre ») : préparation en 10 minutes en cuisinant le double au dîner (temps : 4 → 2), boîte isotherme et plat froid (micro-ondes : 3 → 0). Nouveau total « contre » : 2 + 2 + 0 = **4** ; écart : 10 − 4 = **6** en faveur du changement.

Leçon : la balance aide la personne à **voir** ses raisons ; le professionnel n'ajoute pas ses propres arguments dans la colonne « pour » et ne juge pas les « contre » : il aide à trouver des solutions pour les réduire.

Attention – Entretien motivationnel et santé publique

En groupe, on ne mène pas un entretien motivationnel individuel, mais on en garde l'**esprit** : laisser les participants exprimer leurs raisons, éviter les leçons, valoriser, proposer des choix (« Lequel de ces trois petits changements vous semble faisable cette semaine ? »). Le diététicien formé à l'entretien motivationnel l'utilise en consultation (BC1).

Les quatre processus de l'entretien motivationnel

Dans la troisième édition de leur ouvrage (2013), Miller et Rollnick décrivent l'entretien motivationnel comme une suite de **quatre processus**. Ils se suivent et s'emboîtent : on ne planifie pas avec quelqu'un avec qui l'on n'a pas créé de relation.

Processus	Question centrale	En séance collective
Engager	Pouvons-nous travailler ensemble ?	Accueil, présentation de chacun, règles du groupe, questions ouvertes sur les habitudes
Focaliser	Sur quoi travaillons-nous ?	Choix avec le groupe d'un thème parmi plusieurs (petit-déjeuner, goûters, courses)
Évoquer	Quelles sont les raisons de la personne de changer ?	Faire exprimer ce que chacun aurait à y gagner ; repérer et renforcer le discours-changement
Planifier	Comment va-t-on s'y prendre ?	Chacun choisit un petit objectif et un plan « si…, alors… » (section 3.3.7)

Repérer le discours-changement

Le **discours-changement** regroupe les phrases où la personne parle en faveur du changement. Miller et Rollnick distinguent le discours **préparatoire** (désir, capacité, raisons, besoin) et le discours de **mobilisation** (engagement, activation, premiers pas). Le **discours-maintien** regroupe les phrases en faveur du statu quo (« De toute façon, chez nous on a toujours mangé comme ça »). Le professionnel ne le combat pas : il le reflète et revient au discours-changement.

Catégorie	Exemple entendu en atelier
Désir	« J'aimerais que mes enfants mangent plus de légumes. »
Capacité	« La soupe, je saurais la faire. »
Raisons	« Ça me ferait faire des économies. »
Besoin	« Il faut que je fasse quelque chose, le médecin m'a parlé de mon cholestérol. »
Engagement	« Je vais faire le gratin de lentilles dimanche. »
Activation	« Je suis prête à essayer. »
Premiers pas	« J'ai déjà acheté des pois chiches cette semaine. »

Donner une information sans réflexe correcteur

Méthode pas à pas – Demander, informer, demander (ou explorer, partager, explorer)

1. **Demander** la permission et ce que la personne sait déjà : « Voulez-vous que je vous donne quelques idées sur les goûters ? Qu'est-ce que vous en savez déjà ? »
2. **Informer** brièvement, de façon neutre, en offrant des choix : « Certains parents mettent un fruit et du pain avec un carré de chocolat ; d'autres préparent un laitage… »
3. **Demander** ce que la personne en pense : « Qu'est-ce qui vous paraît faisable chez vous ? »

On évite ainsi la leçon. La personne garde le contrôle et retient mieux ce qu'elle a choisi.

Évaluer sa pratique : quelques repères chiffrés

L'outil d'évaluation de la qualité de la pratique de l'entretien motivationnel, le **MITI** (*Motivational Interviewing Treatment Integrity*, version 4, Moyers et collaborateurs, 2016), compte les questions et les reflets du professionnel sur un enregistrement. Deux repères sont simples à utiliser pour s'auto-évaluer en formation :

- le **rapport reflets / questions** : au moins **1** reflet par question pour une pratique correcte, **2** pour une bonne pratique ;
- la **part de reflets complexes** (qui ajoutent un sens ou un sentiment) parmi tous les reflets : au moins **40 %** pour une pratique correcte, **50 %** pour une bonne pratique.

Calcul détaillé – L'auto-évaluation de Clara, étudiante en BTS

Clara enregistre (avec l'accord des participants) dix minutes d'un échange collectif. Elle compte : **18 questions** (dont 11 ouvertes), **12 reflets simples** et **8 reflets complexes**.

- Nombre total de reflets : 12 + 8 = **20**.
- Rapport reflets / questions : 20 / 18 = **1,11** : pratique correcte, mais pas encore bonne (objectif 2).
- Part de reflets complexes : 8 / 20 = **40 %** : seuil d'une pratique correcte tout juste atteint.
- Part de questions ouvertes : 11 / 18 = **61,1 %**.

Objectif d'amélioration : poser moins de questions et refléter davantage. Pour atteindre un rapport de 2 avec 18 questions, il faudrait 36 reflets ; plus réaliste : passer à 12 questions et 24 reflets, dont au moins la moitié de reflets complexes.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.21

Classez chaque phrase dans une catégorie du discours-changement ou dans le discours-maintien, puis proposez un reflet pour la phrase f. a) « Je pourrais remplacer le soda par de l'eau pétillante. » b) « Je veux pouvoir jouer au foot avec mon fils sans être essoufflé. » c) « J'ai acheté une gourde hier. » d) « Le soda, c'est mon seul plaisir de la journée. » e) « Je vais essayer dès lundi. » f) « Je sais qu'il faudrait, mais avec mon travail de nuit, c'est compliqué. »

Corrigé

a) Capacité. **b)** Raison (ou désir). **c)** Premiers pas. **d)** Discours-maintien. **e)** Engagement. **f)** Ambivalence : besoin (« il faudrait ») et discours-maintien (« c'est compliqué »). Reflet complexe possible : « Vous sentez que ce serait important pour vous, et en même temps vos horaires de nuit rendent les choses difficiles. » Le reflet reprend les deux côtés, en terminant par celui du changement si possible : « Vos horaires compliquent les choses, et pourtant vous sentez que ce serait important pour vous. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 3.3.8 et 3.3.9 – Communiquer, écouter, esprit de l'entretien motivationnel

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez deux principes de l'école de Palo Alto.
2. Pourquoi la « règle des 7 %, 38 %, 55 % » est-elle un mythe ?
3. Quelles sont les trois conditions de l'écoute selon Rogers ?
4. Citez les six attitudes de Porter. Laquelle favorise le plus l'expression ?
5. Nommez les quatre processus de l'entretien motivationnel (2013).
6. Quels sont les deux repères du MITI 4 pour une bonne pratique ?

Corrigé – Point d'étape 3.3.8 et 3.3.9

1. « On ne peut pas ne pas communiquer » ; « toute communication a un contenu et une relation ».
2. Les chiffres de Mehrabian (1967) portent sur des mots isolés exprimant des sentiments, quand le ton et le visage contredisaient le mot.
3. L'empathie, l'acceptation inconditionnelle, la congruence.
4. Évaluation, interprétation, soutien, enquête, solution, compréhension ; c'est la compréhension.
5. Engager, focaliser, évoquer, planifier.
6. Au moins 2 reflets par question et au moins 50 % de reflets complexes.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

3.3.10 Animer un groupe : étapes, rôles et styles d'animation

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

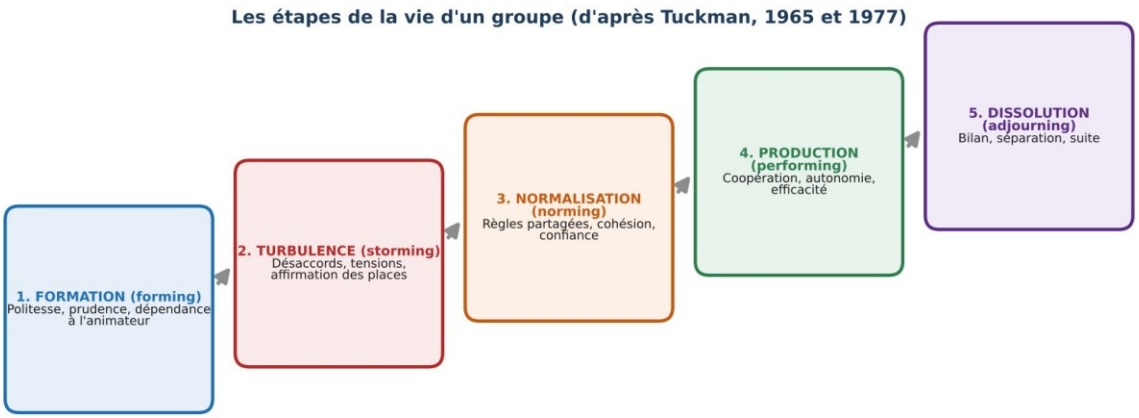


Figure 3.6 – Les étapes de la vie d'un groupe

Comprendre le schéma – Figure 3.6

1. Formation : au début, les participants sont polis et prudents ; ils attendent beaucoup de l'animateur ; c'est le moment de présenter le cadre (règles, confidentialité), de faire se connaître les personnes (brise-glace).

2. Turbulence : des désaccords apparaissent (sur les recettes, les horaires, les façons de faire) ; ils sont **normaux** et signent l'implication ; l'animateur les accueille et aide à les dépasser.

3. Normalisation : le groupe se dote de règles et d'habitudes (« chacun apporte une boîte pour les restes ») ; la cohésion augmente.

4. Production : le groupe coopère, prend des initiatives, l'animateur peut s'effacer (les participants animent une partie de la séance).

5. Dissolution : en fin de cycle, il faut préparer la séparation : bilan, restitution, suite possible (nouveau groupe, autonomie).

6. Dans un cycle de 6 ateliers, ces étapes se succèdent souvent rapidement ; les connaître aide à ne pas s'inquiéter d'une séance tendue (étape 2) et à prévoir la fin (étape 5).

Les rôles dans un groupe

Benne et Sheats (1948) ont distingué trois familles de rôles : les rôles **centrés sur la tâche** (proposer, informer, résumer, organiser), les rôles **centrés sur l'entretien du groupe** (encourager, concilier, faciliter la parole des autres, détendre) et les rôles **individualistes** (monopoliser la parole, bloquer, chercher la reconnaissance, se retirer). L'animateur s'appuie sur les premiers, encourage les seconds et régule les troisièmes.

Situation	Conduite à tenir
Une personne monopolise la parole	Remercier, reformuler brièvement, puis donner la parole aux autres (« J'aimerais entendre ceux qui ne se sont pas encore exprimés ») ; tour de table ; bâton de parole

Situation	Conduite à tenir
Une personne ne parle pas	Ne pas la forcer ; travail en binôme ; supports non verbaux (cartes, gommettes) ; valoriser sa participation pratique
Une personne conteste tout	Accueillir l'objection, la reformuler, la renvoyer au groupe (« Qu'en pensent les autres ? »), s'appuyer sur des données, rappeler l'objectif
Conflit entre deux participants	Rappeler les règles, recentrer sur l'activité, si besoin en parler à part après la séance
Retards répétés	Rappeler les horaires, comprendre les contraintes, adapter l'organisation (accueil café de 15 minutes)
Confidence personnelle difficile	Écouter, remercier, protéger la personne (ne pas laisser le groupe commenter), proposer un échange en privé et une orientation

Les styles d'animation

Exemple – L'expérience de Lewin, Lippitt et White (1939)

Des groupes d'enfants animés selon trois styles ont été comparés. Avec un style **autoritaire** (l'adulte décide de tout), la production était élevée en sa présence, mais l'hostilité et la dépendance aussi, et l'activité s'arrêtait en son absence. Avec un style **démocratique** (décisions discutées, adulte qui guide), la production était bonne, la motivation et la cohésion plus fortes, et le travail continuait sans l'adulte. Avec le style « **laisser-faire** » (adulte passif), la production et la satisfaction étaient les plus faibles. En éducation pour la santé, on privilégie un style **participatif** (démocratique), tout en restant **directif sur le cadre** (sécurité, hygiène, horaires).

Choisir une technique d'animation selon l'objectif

Le style d'animation dit **comment** l'animateur se situe ; la technique dit **ce que** le groupe fait. Le choix dépend de l'objectif de la séquence et de l'étape de vie du groupe. Les techniques sont détaillées au chapitre 14 ; ce tableau en donne la logique psychosociale.

Objectif de la séquence	Technique	Principe	Intérêt psychosocial
Faire connaissance (étape de formation)	Brise-glace, jeu des prénoms, « ce que j'aime manger »	Chacun se présente de façon ludique	Diminue l'anxiété, crée l'appartenance
Recueillir les représentations	Photolangage	Chacun choisit une photo qui évoque pour lui un thème (« bien manger ») et explique son choix	Permet de parler de soi à travers une image, sans être jugé
Produire beaucoup d'idées	Remue-méninges (*brainstorming*, Osborn, 1953)	Toutes les idées sont notées sans critique, puis triées	Limite l'autocensure et l'influence des « experts »
Faire participer un grand groupe	Phillips 6-6	Sous-groupes de 6 personnes, 6 minutes, puis mise en commun	Chacun parle ; on évite la monopolisation
Faire émerger les désaccords	Débat mouvant, abaque de Régnier	Les participants se placent physiquement ou votent par couleur selon leur accord avec une affirmation	Rend visibles les positions ; chacun argumente
Faire décider le groupe	Vote pondéré, consensus	Chacun répartit des gommettes entre plusieurs choix	Engagement collectif (effet Lewin)
S'exercer à une compétence sociale	Jeu de rôle	On joue une situation, puis on en parle	Expérience sans risque, apprentissage par observation

Objectif de la séquence	Technique	Principe	Intérêt psychosocial
Faire le bilan	Cible, « météo », tour de table « un mot »	Chacun s'exprime brièvement sur la séance	Rétroaction, sentiment d'avoir été entendu

Méthode pas à pas – Mener un photolangage

1. Préparer 30 à 50 photos variées (plats, scènes de repas, marchés, publicités), sans texte, en nombre largement supérieur au nombre de participants.
2. Poser une question ouverte : « Choisissez une photo qui représente pour vous "bien manger". »
3. Laisser un temps de choix en silence (5 minutes).
4. Faire un tour de parole : chacun montre sa photo et dit pourquoi il l'a choisie ; les autres écoutent sans commenter.
5. Reformuler et noter les idées qui reviennent (éléments partagés) et celles qui sont isolées.
6. Faire une synthèse avec le groupe, qui servira de point de départ au cycle d'ateliers.

Définition – Le jeu de rôle et le débriefing

Le **jeu de rôle** fait vivre une situation proche de la réalité (dire non à une invitation au fast-food, demander un conseil au boucher). Il comporte trois temps : la **consigne** (situation, rôles, durée), le **jeu** (quelques minutes), le **débriefing**. Le débriefing est la partie la plus importante : on demande d'abord à l'acteur ce qu'il a ressenti, puis aux observateurs ce qu'ils ont vu de positif, puis ce qu'on pourrait essayer autrement. On ne juge jamais la personne, seulement la stratégie utilisée. Un participant qui ne veut pas jouer peut observer.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.22

Vous animez la première séance d'un cycle de six ateliers avec 14 adultes d'une association d'insertion. Vos objectifs sont : faire connaissance, recueillir leurs représentations de l'alimentation à petit budget, et choisir avec eux les thèmes des cinq séances suivantes. a) Choisissez une technique pour chaque objectif et justifiez. b) À quelle étape de la vie du groupe êtes-vous ? Quelle attitude adoptez-vous ?

Corrigé

a) Faire connaissance : un **brise-glace** (« mon prénom et un plat qui me rappelle mon enfance ») : rapide, ludique, il crée du lien et valorise l'identité de chacun. Représentations : un **photolangage** sur « manger bien avec peu d'argent » : l'image facilite la parole, sans mise en échec. Choix des thèmes : un **vote par gommettes** parmi 8 thèmes proposés (dont certains issus du photolangage) : la décision collective engage le groupe. **b)** Étape de **formation** : les participants sont prudents et attendent des repères ; l'animateur est plutôt directif sur le cadre (horaires, règles, confidentialité), chaleureux et rassurant, et laisse progressivement la place aux décisions du groupe.

Quatre phénomènes de groupe à connaître

Le travail en groupe n'a pas que des avantages. La psychologie sociale a décrit des phénomènes qui expliquent pourquoi un groupe peut produire moins, ou décider moins bien, que la somme de ses membres.

Phénomène	Ce qui se passe	Origine	Prévention en atelier ou en réunion de projet
Cohésion	Force des liens qui retiennent les membres dans le groupe ; elle favorise la participation et la persévérance	Festinger, Schachter et Back (1950)	Rituels d'accueil, tâches en commun, règles décidées ensemble, repas partagé à la fin

Phénomène	Ce qui se passe	Origine	Prévention en atelier ou en réunion de projet
Paresse sociale	Chacun fournit moins d'effort quand la contribution individuelle n'est pas visible	Ringelmann (fin du XIXe siècle, traction d'une corde) ; Latané, Williams et Harkins (1979)	Donner à chacun un rôle identifiable (éplucher, peser, dresser) ; petits sous-groupes
Pensée de groupe	Un groupe très soudé cherche l'unanimité et écarte les avis contraires, au risque d'une mauvaise décision	Irving Janis (1972)	Demander des avis contraires, désigner un « avocat du diable », consulter des personnes extérieures
Polarisation de groupe	Après discussion, la position du groupe devient plus extrême que la moyenne des positions individuelles	Moscovici et Zavalloni (1969)	Apporter des données, faire voter individuellement avant la discussion

Exemple – La pensée de groupe dans un comité de pilotage

Le comité de pilotage d'un projet de quartier réunit depuis trois ans les mêmes cinq professionnels, très liés. Il décide de reconduire à l'identique les ateliers « équilibre alimentaire », malgré une fréquentation en baisse (de 14 à 5 participants). Personne n'ose dire que les ateliers ne répondent plus aux attentes ; les quelques remarques des habitants sont jugées « marginales ». On retrouve les signes décrits par Janis : **illusion d'unanimité**, **autocensure**, mise à l'écart des informations dérangeantes. **Remède** : présenter les données de fréquentation, inviter deux habitants au comité, faire un tour de table où chacun dit une critique avant la décision.

Définition – Le leadership dans un groupe

Le **leader** est la personne qui influence le plus le groupe à un moment donné. Ce n'est pas forcément l'animateur. On distingue un leadership **orienté vers la tâche** (organiser, décider, faire avancer) et un leadership **orienté vers les relations** (rassurer, encourager, apaiser). Dans un atelier, un participant leader peut être un allié précieux (il goûte en premier, il entraîne les autres) ou un frein (il se moque, il décourage). L'animateur s'appuie sur les leaders positifs, en leur confiant un rôle, et régule les autres sans les mettre en échec devant le groupe.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.23

Dans un atelier culinaire de 12 adultes, l'animatrice répartit les participants en deux équipes de 6 pour préparer un couscous de légumes. Elle remarque que, dans chaque équipe, deux personnes font tout pendant que les autres discutent. a) Quel phénomène observe-t-elle ? Citez son origine. b) Proposez deux changements d'organisation. c) Comment la cohésion du groupe peut-elle aussi être renforcée à cette occasion ?

Corrigé

a) La **paresse sociale** : dans un grand sous-groupe, la contribution de chacun est peu visible, donc l'effort individuel baisse (Ringelmann ; Latané, Williams et Harkins, 1979). **b)** Former des **binômes** ou des trinômes avec une tâche précise chacun (légumes, semoule, bouillon, épices, dressage) ; afficher le **plan de travail** avec le prénom de chacun en face de sa tâche. **c)** Terminer par un **repas partagé** où chaque binôme présente sa partie, remercier chacun pour sa contribution, et faire choisir au groupe la recette de la séance suivante.

Gérer un désaccord ou un conflit : deux méthodes

Les désaccords sont normaux dans un groupe (étape de turbulence). Ils deviennent un problème quand ils se transforment en attaques personnelles. Deux méthodes simples aident l'animateur à exprimer une difficulté sans agresser et à aider les participants à le faire.

Méthode pas à pas – La méthode DESC (Bower et Bower, 1976)

D – Décrire les faits, sans jugement : « Depuis le début de la séance, le téléphone a sonné quatre fois. »

E – Exprimer ce que l'on ressent ou les conséquences : « J'ai du mal à garder l'attention du groupe, et les autres n'entendent pas les consignes de sécurité. »

S – Suggérer une solution précise : « Je vous propose de le mettre en silencieux et de sortir si vous devez répondre. »

C – Conclure sur les conséquences positives : « Comme ça, tout le monde pourra profiter de l'atelier, et vous ne manquerez pas d'appel important. »

Définition – La communication non violente (Marshall Rosenberg, 1999)

Démarche de communication en quatre étapes, proche de la méthode DESC : **observation** des faits sans évaluation, expression du **sentiment**, expression du **besoin** à l'origine du sentiment, formulation d'une **demande** concrète, réalisable et négociable. Elle aide à transformer un reproche (« Vous ne respectez rien ») en une demande que l'autre peut entendre (« Quand vous arrivez après le début de la recette [observation], je suis inquiète [sentiment] car j'ai besoin que chacun entende les consignes d'hygiène [besoin]. Pourriez-vous arriver à 14 h la prochaine fois, ou me prévenir ? [demande] »).

Erreur fréquente	Pourquoi elle aggrave le conflit	Formulation alternative
Généraliser (« Vous êtes toujours en retard »)	La personne se défend contre l'étiquette, pas sur les faits	« Vous êtes arrivé après le début les deux dernières fois. »
Parler à la place de l'autre (« Vous vous en fichez »)	Interprétation, attitude de Porter qui ferme le dialogue	« Je me demande si l'horaire vous convient. »
Recadrer devant tout le groupe	Menace pour l'image de la personne, risque d'humiliation	Un mot bref en séance, puis un échange à part
Laisser faire	Le groupe perçoit que les règles ne comptent pas	Rappeler calmement la règle décidée ensemble

À vous de jouer – Exercice d'application 3.24

Pendant un atelier, deux participantes se disputent : l'une reproche à l'autre de « tout faire à sa façon » et de ne pas la laisser cuisiner. Le ton monte. a) Que faites-vous immédiatement ? b) Rédigez, selon la méthode DESC, ce que vous direz à la participante qui accapare la tâche, en aparté. c) Quelle règle proposer au groupe pour la suite ?

Corrigé

a) Interrompre calmement, rappeler les règles du groupe (bienveillance, chacun participe), **recentrer** sur la tâche en répartissant les rôles (« Mme X, vous vous occupez de la sauce ; Mme Y, des légumes »), et proposer d'en reparler après la séance. **b)** « Tout à l'heure, vous avez pris en charge la découpe et la cuisson pendant que Mme Y attendait (D). Je vois que vous savez bien cuisiner, mais Mme Y n'a pas pu pratiquer, et elle est venue pour apprendre (E). La prochaine fois, je vous propose de lui montrer un geste puis de la laisser faire (S) : votre savoir-faire servira à tout le groupe et l'ambiance sera meilleure (C). » **c)** Une règle de **rotation des tâches** décidée avec le groupe et affichée : chacun réalise au moins une étape de la recette.

3.3.11 La motivation et les biais de décision

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

La théorie de l'autodétermination

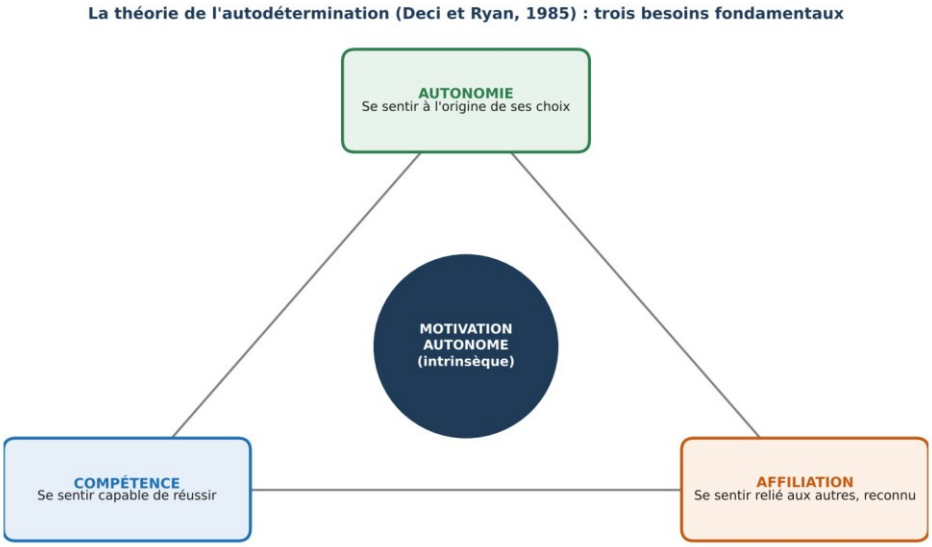


Figure 3.7 – Les trois besoins psychologiques fondamentaux

Comprendre le schéma – Figure 3.7

1. Deci et Ryan (1985) distinguent la motivation **intrinsèque** (agir pour le plaisir ou l'intérêt de l'activité), la motivation **extrinsèque** (agir pour une récompense, éviter une sanction, faire plaisir à quelqu'un) et l'**amotivation**.
2. Les motivations les plus durables sont **autonomes** : intrinsèques ou extrinsèques mais **intériorisées** (« Je cuisine parce que c'est important pour moi d'élever mes enfants en bonne santé »).
3. Elles sont favorisées par la satisfaction de trois besoins : **autonomie** (choisir), **compétence** (réussir), **affiliation** (se sentir relié aux autres).
4. Conséquences pour l'animation : laisser choisir (recettes, défis), proposer des tâches réalisables et valoriser les réussites, créer de la convivialité ; éviter les récompenses et les menaces qui affaiblissent la motivation intrinsèque (« Si tu finis tes légumes, tu auras un dessert » apprend à l'enfant que le légume est une corvée et le dessert une récompense).

Les biais cognitifs et les choix alimentaires

Le psychologue Daniel **Kahneman** (prix Nobel d'économie 2002) distingue un **système 1**, rapide, automatique et émotionnel, et un **système 2**, lent, réfléchi et coûteux en effort (*Système 1 / Système 2 : les deux vitesses de la pensée*, 2011). Une grande partie des choix alimentaires quotidiens, rapides et répétés, relève du système 1 : d'où les **biais**, utilisés par le marketing et, à l'inverse, par les **nudges** (chapitre 6).

Biais	Exemple alimentaire et usage en prévention
Préférence pour le présent	Le plaisir immédiat (dessert) l'emporte sur un bénéfice futur (santé dans 20 ans) : valoriser les bénéfices immédiats (énergie, goût, économies)
Effet de cadrage	« 95 % sans matière grasse » paraît plus sain que « 5 % de matière grasse » ; présenter les messages de façon positive

Biais	Exemple alimentaire et usage en prévention
Effet de halo	Un produit étiqueté « bio » ou « naturel » paraît moins calorique ; apprendre à lire l'étiquette entière
Biais de statu quo / option par défaut	On garde l'option proposée d'office : servir les légumes par défaut, l'eau en carafe
Ancrage	Le premier prix vu sert de référence ; une grande portion servie devient la norme (chapitre 4)
Biais d'optimisme	« Les maladies, ça arrive aux autres » : limite des messages fondés sur la peur
Preuve sociale	On imite ce que font les autres : normes descriptives positives (« 7 familles sur 10 ont goûté… »)

Le continuum de l'autodétermination

Deci et Ryan ne se contentent pas d'opposer motivation intrinsèque et extrinsèque. Ils décrivent un **continuum** : la motivation extrinsèque peut être plus ou moins **intériorisée**, c'est-à-dire faire plus ou moins partie des valeurs de la personne.

Type de motivation	Régulation	Ce que dit la personne	Durabilité
Amotivation	Aucune	« Je ne vois pas à quoi ça sert. »	Nulle
Extrinsèque	Externe	« Je mange des légumes pour que le médecin arrête de me sermonner. »	Faible : s'arrête avec la pression
Extrinsèque	Introjectée	« Je me sentirais coupable de ne pas en manger. »	Faible à moyenne : liée à la culpabilité
Extrinsèque	Identifiée	« C'est important pour ma santé, j'en vois l'intérêt. »	Bonne
Extrinsèque	Intégrée	« Cuisiner frais fait partie de qui je suis, comme parent. »	Très bonne
Intrinsèque	Intrinsèque	« J'adore cuisiner les légumes, c'est un plaisir. »	Très bonne

Exemple – L'effet de surjustification (Lepper, Greene et Nisbett, 1973)

Dans une école maternelle, des enfants qui aimaient spontanément dessiner avec des feutres ont été répartis en trois groupes. Le premier savait qu'il recevrait un diplôme s'il dessinait ; le deuxième l'a reçu par surprise ; le troisième n'a rien reçu. Une à deux semaines plus tard, pendant le temps libre, les enfants du premier groupe ont passé environ **deux fois moins de temps** à dessiner que ceux des deux autres groupes (environ 9 % du temps libre contre 17 à 18 %).

Explication : la récompense **attendue** a transformé une activité plaisante en « travail » fait pour obtenir quelque chose. **Leçon** : récompenser un enfant parce qu'il a goûté un légume risque de diminuer son envie d'en manger quand il n'y a plus de récompense. La reconnaissance **verbale**, sincère et inattendue, ne produit pas cet effet.

Les nudges et leurs limites éthiques

Définition – Nudge (Thaler et Sunstein, 2008)

Un **nudge** (« coup de pouce ») est une modification de l'**architecture du choix** qui oriente le comportement de façon prévisible, **sans interdire** aucune option et **sans changer** significativement les incitations financières. Mettre les fruits à hauteur des yeux est un nudge ; interdire les sodas n'en est pas un.

Exemple – Plus d'options végétariennes, plus de repas végétariens (Garnett et collaborateurs, 2019)

Dans les cafétérias de l'université de Cambridge, des chercheurs ont fait varier la part des plats végétariens proposés. En passant d'une option végétarienne sur quatre à **deux sur quatre**, les ventes de plats végétariens ont augmenté de **40 à 80 %** selon les cafétérias, sans baisse des ventes totales. Les clients qui mangeaient le moins souvent végétarien étaient les plus sensibles au changement (étude publiée dans *PNAS*). C'est un levier de l'**opportunité physique** (modèle COM-B), cohérent avec l'obligation d'un menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire posée par la loi EGalim (2018) et pérennisée par la loi Climat et résilience (2021).

Critère éthique	Question à se poser	Exemple
Transparence	La personne pourrait-elle repérer le nudge et le comprendre si on le lui expliquait ?	Une affiche « Ce mois-ci, le plat du jour est végétarien » est transparente
Liberté de choix	Toutes les options restent-elles accessibles sans effort excessif ?	Les desserts restent proposés, mais en fin de ligne
Intérêt de la personne	Le nudge sert-il la santé de la personne plutôt qu'un intérêt commercial ?	Mettre en avant l'eau plutôt que le soda à forte marge
Équité	Le nudge bénéficie-t-il aussi, et même surtout, aux plus défavorisés ?	Une option par défaut équilibrée profite à tous, sans effort ni coût
Respect	Le nudge évite-t-il la honte et la stigmatisation ?	Pas de messages culpabilisants sur les plateaux

Attention – Un nudge ne remplace pas une politique

Les nudges ont souvent des effets **modestes** et variables d'un lieu à l'autre. Ils ne corrigent pas les inégalités de revenus, de temps ou d'accès aux commerces. Ils complètent l'éducation pour la santé et les mesures structurelles (réglementation, prix, offre) ; ils ne s'y substituent pas (chapitres 1 et 6).

À vous de jouer – Exercice d'application 3.25

Un restaurant d'entreprise envisage trois mesures : A) placer les crudités en début de ligne et les frites en fin de ligne ; B) supprimer les desserts ; C) offrir un dessert gratuit pour chaque plateau « équilibré » validé par une application. a) Laquelle est un nudge au sens strict ? Justifiez pour chacune. b) Que prévoit la théorie de l'autodétermination pour la mesure C ? c) Vérifiez l'éthique de la mesure A avec deux critères.

Corrigé

a) A est un nudge : on modifie l'ordre de présentation, toutes les options restent accessibles, les prix ne changent pas. **B** n'est pas un nudge : c'est une **restriction** (une option est supprimée). **C** n'est pas un nudge : c'est une **incitation financière** (un avantage matériel). **b)** La récompense attendue risque de déplacer la motivation vers une **régulation externe** : les salariés composent un plateau « équilibré » pour le dessert gratuit et risquent d'arrêter quand l'offre s'arrête (effet de surjustification). **c) Transparence** : le placement est visible et peut être expliqué par une affiche. **Liberté** : les frites restent disponibles au même prix. La mesure sert l'intérêt des salariés et ne stigmatise personne.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 3.3.10 et 3.3.11 – Animer un groupe, motivation, biais

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les cinq étapes de la vie d'un groupe selon Tuckman.
2. Quelles sont les trois familles de rôles de Benne et Sheats ?
3. Quel style d'animation l'expérience de Lewin, Lippitt et White (1939) recommande-t-elle ? Pourquoi ?

4. Rangez du moins au plus autodéterminé : régulation identifiée, régulation externe, motivation intrinsèque, régulation introjectée.
5. Qu'est-ce que l'effet de surjustification ? Citez l'expérience qui l'a montré.
6. Donnez la définition d'un nudge et un exemple.

Corrigé – Point d'étape 3.3.10 et 3.3.11

1. Formation, turbulence (tension), normalisation, production, dissolution.
2. Les rôles centrés sur la tâche, centrés sur l'entretien du groupe, individualistes.
3. Le style démocratique (participatif) : bonne production, motivation et cohésion fortes, travail qui continue sans l'adulte.
4. Régulation externe, régulation introjectée, régulation identifiée, motivation intrinsèque.
5. Une récompense attendue diminue la motivation intrinsèque pour une activité plaisante (Lepper, Greene et Nisbett, 1973 : enfants et feutres).
6. Une modification de l'architecture du choix qui oriente le comportement sans interdire d'option ni changer les incitations financières (Thaler et Sunstein, 2008) : fruits à hauteur des yeux.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

3.3.12 Mesurer attitudes et représentations

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

Les représentations et les attitudes (3.3.3, 3.3.4) peuvent être **recueillies** et **mesurées** pour le diagnostic et l'évaluation. Trois méthodes sont simples à utiliser sur le terrain.

L'échelle de Likert

Méthode pas à pas – Construire et calculer un score d'attitude

Une échelle de **Likert** (1932) propose des affirmations avec lesquelles la personne indique son degré d'accord, généralement de 1 (« pas du tout d'accord ») à 5 (« tout à fait d'accord »). On mélange des affirmations **positives** et **négatives** pour limiter les réponses automatiques, et l'on **inverse** le score des affirmations négatives (score inversé = 6 − réponse) avant d'additionner.

Exemple – Calcul détaillé : score d'attitude envers les légumes secs

Affirmations : A1 « Les légumes secs sont bons pour la santé » (+) ; A2 « Les légumes secs sont difficiles à cuisiner » (−) ; A3 « Mes enfants aimeraient les légumes secs » (+) ; A4 « Les légumes secs, c'est un plat du pauvre » (−) ; A5 « J'aimerais en cuisiner plus souvent » (+). Réponses de Mme D. : A1 = 4 ; A2 = 5 ; A3 = 2 ; A4 = 3 ; A5 = 4.

- Inversion des items négatifs : A2 : 6 − 5 = **1** ; A4 : 6 − 3 = **3**.
- Score total : 4 + 1 + 2 + 3 + 4 = **14** sur un maximum de 5 × 5 = **25** (minimum 5).
- Score ramené sur 100 : (14 − 5) / (25 − 5) × 100 = 9 / 20 × 100 = **45 / 100**.
- **Lecture** : attitude plutôt neutre, avec un frein majeur sur la **difficulté perçue** (A2 = 1 après inversion) : un atelier pratique renforçant le sentiment d'efficacité personnelle (Bandura) est prioritaire ; l'image « plat

du pauvre » (A4) appelle des recettes valorisantes.
Après le cycle d'ateliers : A1 = 5 ; A2 = 2 ; A3 = 3 ; A4 = 2 ; A5 = 5. Inversions : A2 : 6 − 2 = 4 ; A4 : 6 − 2 = 4.
Total : 5 + 4 + 3 + 4 + 5 = **21** ; sur 100 : (21 − 5) / 20 × 100 = **80 / 100** (+ 35 points).

L'évocation hiérarchisée et l'analyse prototypique

Méthode pas à pas – Recueillir une représentation sociale par évocation (Vergès, 1992)

1. Poser une consigne d'**association libre** : « Quels sont les 3 à 5 mots qui vous viennent à l'esprit quand on dit "manger équilibré" ? »
2. Noter les mots dans l'**ordre** où ils sont cités (rang 1, 2, 3…).
3. Regrouper les mots de même sens (« cher », « coûte cher », « prix »).
4. Calculer pour chaque mot sa **fréquence** (nombre de personnes qui le citent) et son **rang moyen** d'apparition.
5. Fixer deux seuils : une fréquence (souvent la fréquence médiane ou un seuil choisi) et le rang moyen général.
6. Classer les mots dans un tableau à quatre cases : le **noyau central** probable (mots fréquents et cités tôt), les périphéries, les éléments contrastés.

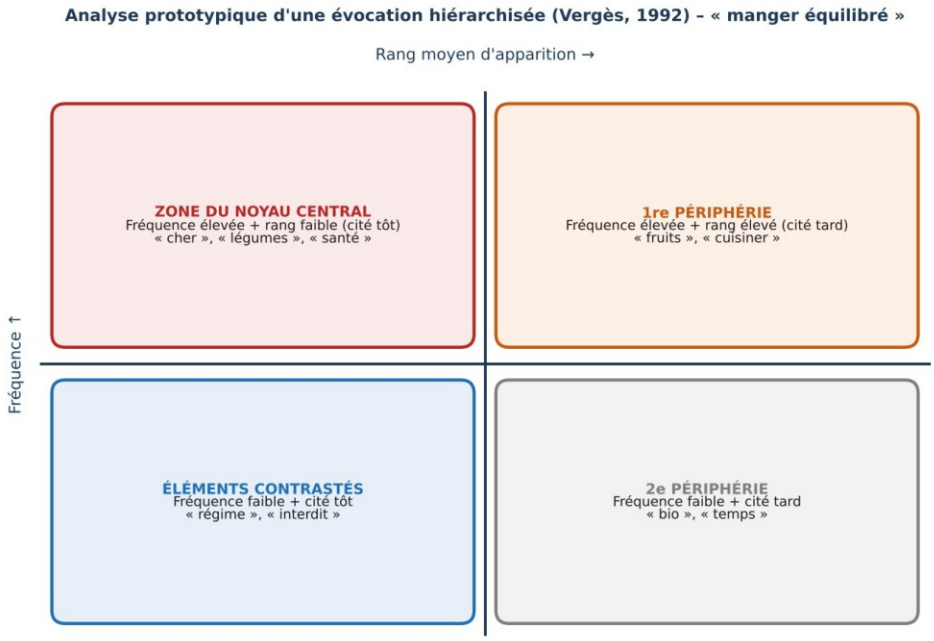


Figure 3.8 – L'analyse prototypique d'une évocation

Exemple – Calcul détaillé : la représentation de « manger équilibré » chez 30 parents

Mot (regroupé)	Fréquence	Rang moyen	Fréquence × rang
cher	21	1,6	33,6
légumes	18	1,9	34,2
fruits	16	2,9	46,4
santé	15	2,1	31,5
cuisiner	13	3,2	41,6
régime	6	1,8	10,8
interdit	5	2,0	10,0

Mot (regroupé)	Fréquence	Rang moyen	Fréquence × rang
temps	5	3,1	15,5
bio	4	3,4	13,6
Total	103		237,2

- Rang moyen général = somme (fréquence × rang) / somme des fréquences = 237,2 / 103 = **2,30**.
- Seuil de fréquence retenu : **10** (au moins un tiers des personnes).
- **Noyau central** probable (fréquence ≥ 10 et rang < 2,30) : **cher** (1,6), **légumes** (1,9), **santé** (2,1).
- **1re périphérie** (fréquence ≥ 10 et rang ≥ 2,30) : **fruits** (2,9), **cuisiner** (3,2).
- **Éléments contrastés** (fréquence < 10 et rang < 2,30) : **régime** (1,8), **interdit** (2,0) : une minorité associe l'équilibre à la privation.
- **2e périphérie** : **temps** (3,1), **bio** (3,4).

Interprétation : pour ces parents, « manger équilibré » est d'abord lié au **coût** et à la **santé** : le projet doit démontrer qu'on peut manger équilibré à petit prix (argument central), sans moraliser ; les éléments « régime » et « interdit » signalent un risque de restriction cognitive chez quelques personnes (chapitre 4). Le noyau central étant stable et résistant, on ne cherche pas à le « supprimer » mais à le **faire évoluer** par l'expérience (calcul du coût par portion en atelier).

Attention – Limites

L'analyse prototypique repère un noyau central **probable** ; sa confirmation demande d'autres méthodes (questionnaires de mise en cause). Sur de petits effectifs, les seuils sont fragiles : présentez les fréquences et restez prudent.

Le différenciateur sémantique

Définition – Différenciateur sémantique (Osgood, Suci et Tannenbaum, 1957)

Outil qui mesure la **signification** et l'**image** d'un objet (un aliment, un lieu, une action) à l'aide de paires d'adjectifs opposés placés aux deux extrémités d'une échelle, en général en 7 points. La personne coche la case qui correspond à son impression. On obtient un **profil** que l'on peut comparer entre groupes ou avant et après une action.

Calcul détaillé – L'image du « restaurant scolaire » chez 20 collégiens, avant et après un projet participatif (données fictives)

Échelle de 1 (adjectif de gauche) à 7 (adjectif de droite). Moyennes du groupe :

Paire d'adjectifs	Avant	Après	Évolution
Bruyant – calme	2,1	3,4	+1,3
Pas bon – bon	3,0	4,6	+1,6
Ennuyeux – convivial	3,5	4,9	+1,4
Imposé – choisi	2,4	4,2	+1,8
Pour les petits – pour les grands	2,8	3,1	+0,3

- Moyenne générale avant : (2,1 + 3,0 + 3,5 + 2,4 + 2,8) / 5 = 13,8 / 5 = **2,76**.
- Moyenne générale après : (3,4 + 4,6 + 4,9 + 4,2 + 3,1) / 5 = 20,2 / 5 = **4,04**, soit **+1,28** point.

Lecture : la plus forte évolution porte sur « imposé – choisi » (+1,8), cohérente avec un projet où les élèves

ont participé au choix des menus (besoin d'**autonomie**, section 3.3.11). L'image « pour les petits » a très peu changé : c'est une piste pour la suite (repas à thème choisis par les 3e, décoration). Sur 20 élèves, ces écarts restent des **tendances** à confirmer.

Exploiter des réponses libres : l'analyse de contenu

Les entretiens, les groupes de parole et les questions ouvertes produisent des **réponses libres**. Pour les exploiter, on réalise une **analyse de contenu** (Bardin, 1977).

Méthode pas à pas – Réaliser une analyse de contenu thématique simple

1. **Retranscrire** fidèlement les réponses ou les notes, en anonymisant.
2. **Lire** l'ensemble une première fois sans rien coder (lecture flottante).
3. **Découper** le texte en unités de sens (une idée par unité).
4. **Construire une grille de thèmes** à partir des objectifs et de ce qui ressort (coût, temps, goût des enfants, santé, culture…).
5. **Coder** chaque unité dans un thème ; compter le nombre de personnes qui évoquent chaque thème.
6. **Illustrer** chaque thème par une ou deux citations courtes et anonymes.
7. **Interpréter** en lien avec les modèles (COM-B, croyances relatives à la santé) et faire relire le codage par une autre personne si possible.

Les qualités d'un outil de mesure

Qualité	Question	Comment la vérifier simplement
Validité	L'outil mesure-t-il bien ce qu'il prétend mesurer ?	Utiliser un outil déjà validé ; faire relire par des experts ; vérifier que les items couvrent tout le concept
Fidélité	Donne-t-il des résultats stables ?	Faire répondre deux fois les mêmes personnes à quelques jours d'écart (test-retest) ; vérifier la cohérence des items entre eux (alpha de Cronbach, Cronbach 1951 : une valeur d'au moins 0,70 est souvent jugée acceptable)
Sensibilité	Détecte-t-il un changement ?	Éviter les échelles trop courtes ; vérifier qu'au départ les réponses ne sont pas toutes au maximum (effet plafond)
Acceptabilité	Le public peut-il y répondre facilement ?	Pré-test, durée de passation, vocabulaire

Méthode pas à pas – Pré-tester un questionnaire d'attitudes

1. Faire passer le questionnaire à 5 à 10 personnes semblables au public visé, mais qui ne feront pas partie de l'enquête.
2. Chronométrer la passation.
3. Demander après chaque question : « Comment avez-vous compris cette question ? » (entretien cognitif).
4. Repérer les mots incompris, les questions qui orientent la réponse, les doubles questions (« Aimez-vous les fruits et les légumes ? »), les réponses manquantes.
5. Corriger puis, si les changements sont importants, refaire un court pré-test.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.26

Une étudiante prépare une échelle de Likert pour mesurer l'attitude de parents envers la cantine. Voici trois

items : 1) « Les repas de la cantine sont bons et équilibrés. » 2) « Ne pensez-vous pas que les enfants gaspillent trop ? » 3) « La cantine est bien. » a) Repérez le défaut de chaque item. b) Réécrivez-les. c) Comment vérifier que l'échelle est acceptable avant l'enquête ?

Corrigé

a) Item 1 : **double question** (on peut trouver les repas bons mais pas équilibrés). Item 2 : question **orientée** et posée sous forme interrogative alors qu'une échelle de Likert demande une affirmation. Item 3 : formulation **vague** (« bien » ne dit pas sur quoi porte le jugement). **b)** « Les repas de la cantine ont bon goût. » ; « Les repas de la cantine sont équilibrés. » ; « Les enfants laissent beaucoup de nourriture dans leur assiette. » ; « Mon enfant est content de manger à la cantine. » **c)** Par un **pré-test** auprès de 5 à 10 parents qui ne participeront pas à l'enquête : durée, compréhension de chaque item, vocabulaire, puis correction.

3.3.13 Un modèle intégrateur : COM-B et la roue du changement de comportement

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

Les modèles présentés (croyances relatives à la santé, comportement planifié, étapes du changement, efficacité personnelle) éclairent chacun une partie du changement. Susan **Michie** et ses collègues (2011) ont proposé, à partir d'une revue de 19 modèles, un cadre **intégrateur** très utilisé en santé publique : le modèle **COM-B**, au cœur de la « roue du changement de comportement » (*Behaviour Change Wheel*).

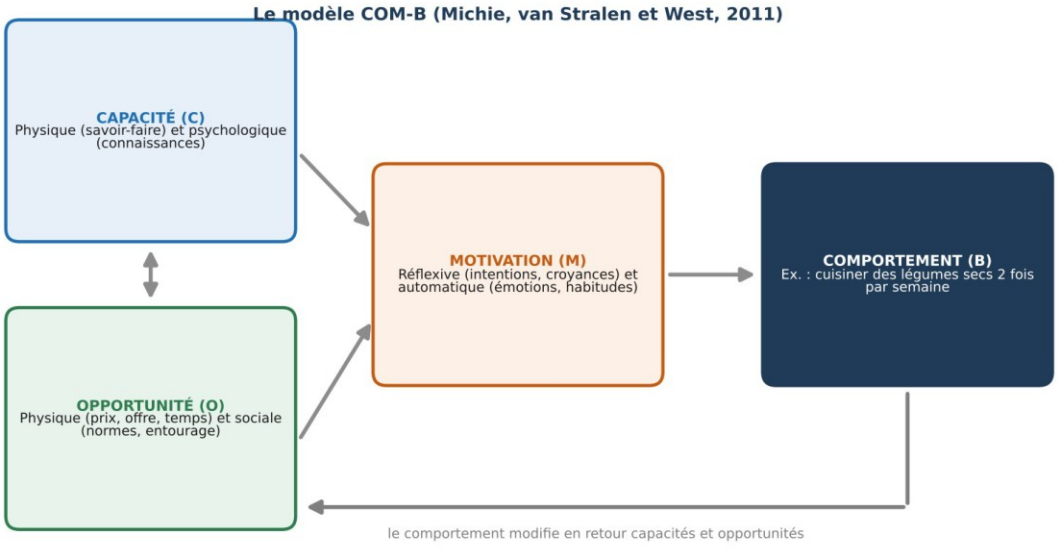


Figure 3.9 – Le modèle COM-B

Comprendre le schéma – Figure 3.9

1. Un **comportement** (B, *behaviour*) se produit quand trois conditions sont réunies : la **capacité** (C), l'**opportunité** (O) et la **motivation** (M).

2. Capacité : physique (savoir cuisiner, éplucher, utiliser un four) et psychologique (connaissances, compréhension, mémoire, organisation).

3. Opportunité : physique (prix, offre disponible, temps, équipement, accès) et sociale (normes, soutien de l'entourage, culture).

4. Motivation : réflexive (intentions, croyances, objectifs, identité) et automatique (émotions, désirs, habitudes, impulsions).

5. Capacité et opportunité influencent la motivation ; le comportement, une fois installé, renforce en retour

les capacités et les opportunités (on sait mieux faire, on achète autrement).

6. Intérêt : le diagnostic identifie **quelle composante manque** ; l'action est choisie en conséquence. Si le frein est l'opportunité (pas de commerce, pas de cuisine), une action purement informative (capacité psychologique) échouera.

Composante en défaut	Fonction d'intervention (roue du changement)	Exemple en nutrition
Capacité psychologique	Éducation (informer, faire comprendre)	Repères, lecture d'étiquettes
Capacité physique	Formation (apprendre des savoir-faire)	Atelier culinaire, gestes de découpe
Motivation réflexive	Persuasion, incitation	Témoignages, arguments d'économie, défis
Motivation automatique	Modélisation, aménagement de l'environnement, habitudes	Plats déjà prêts à goûter, routines (« légumes à chaque repas »)
Opportunité physique	Restructuration de l'environnement, facilitation	Fruits à la récréation, épicerie solidaire, micro-ondes en salle de pause
Opportunité sociale	Modélisation, soutien social, normes	Mamans relais, repas partagés, normes descriptives positives

Exemple – Analyse COM-B : pourquoi les familles ne cuisinent-elles pas de légumes secs ?

- **Capacité psychologique** : connaissances limitées sur la cuisson et l'intérêt nutritionnel (58 % « ne savent pas les cuisiner », chapitre 1).
- **Capacité physique** : peu de pratique (trempage, cuisson).
- **Opportunité physique** : produits disponibles à l'épicerie solidaire et peu chers (0,16 € la portion) : **pas de frein majeur** ; temps de cuisson perçu comme long (lentilles corail : 15 minutes).
- **Opportunité sociale** : représentation « plat du pauvre », enfants peu habitués.
- **Motivation** : réflexive favorable (envie d'économiser, 54 % demandent des ateliers) ; automatique défavorable (habitude des pâtes, des plats préparés).

Conclusion : les fonctions prioritaires sont la **formation** (atelier pratique), la **modélisation** (dégustation, mamans relais) et la **création d'habitudes** (recette « du mardi »), plutôt que l'information seule.

La roue du changement de comportement en entier

Le modèle COM-B est le **moyeu** d'une roue à trois anneaux (Michie, van Stralen et West, 2011). Autour de lui, **neuf fonctions d'intervention** ; à l'extérieur, **sept catégories de politiques** qui permettent de les mettre en œuvre.

Fonction d'intervention	Définition	Exemple en nutrition
Éducation	Augmenter les connaissances ou la compréhension	Atelier de lecture d'étiquettes
Persuasion	Utiliser la communication pour susciter des émotions positives ou négatives, ou stimuler l'action	Témoignage d'un pair qui a changé ses goûters
Incitation	Créer une attente de récompense	Chèques fruits et légumes dans une épicerie solidaire
Coercition	Créer une attente de sanction ou de coût	Taxe sur les boissons sucrées (créée en 2012, rendue progressive selon le sucre en 2018, relevée le 1er mars 2025)
Formation	Transmettre des savoir-faire	Atelier culinaire

Fonction d'intervention	Définition	Exemple en nutrition
Restriction	Utiliser des règles pour réduire les occasions d'un comportement	Interdiction des distributeurs automatiques payants dans les écoles (loi de 2004)
Restructuration de l'environnement	Changer le contexte physique ou social	Fontaines à eau, carafes sur les tables
Modélisation	Fournir un exemple à imiter	Animateur et parents qui goûtent devant les enfants
Facilitation	Réduire les obstacles ou augmenter les moyens	Garde d'enfants pendant l'atelier, transport

Catégorie de politique	Exemple
Communication et marketing	Campagnes « Manger Bouger »
Lignes directrices	Recommandations du PNNS, guide du GEM-RCN
Mesures fiscales	Taxe soda
Réglementation	Encadrement de la publicité alimentaire destinée aux enfants
Législation	Loi EGalim (2018) : 50 % de produits durables dont 20 % bio en restauration collective
Aménagement de l'environnement et de l'espace social	Jardins partagés, aménagement des selfs
Prestation de services	Consultations diététiques, ateliers de quartier

La taxonomie des techniques de changement de comportement

Pour décrire précisément ce que contient une intervention, Michie et ses collègues ont publié en 2013 une **taxonomie** de **93 techniques de changement de comportement** (en anglais *BCT Taxonomy v1*), regroupées en **16 groupes**. Elle permet de comparer les interventions et de savoir quels « ingrédients actifs » sont efficaces.

Exemple de technique (groupe)	Ce que fait l'intervenant
Fixation d'objectif comportemental (objectifs et planification)	Aide la personne à fixer un objectif précis
Planification de l'action (objectifs et planification)	Fait préciser quand, où et comment agir (« si..., alors... »)
Résolution de problèmes (objectifs et planification)	Fait identifier les obstacles et leurs solutions
Auto-surveillance du comportement (rétroaction et surveillance)	Propose un carnet pour noter les portions de légumes
Soutien social pratique (soutien social)	Organise un binôme de courses
Démonstration du comportement (modélisation)	Montre la découpe des légumes
Répétition et entraînement (répétition et substitution)	Fait refaire la recette plusieurs fois
Restructuration de l'environnement physique (antécédents)	Aide à ranger les fruits en vue dans la cuisine
Récompense non spécifique (récompense et menace)	Félicite le groupe

Méthode pas à pas – Concevoir une intervention avec la roue (huit étapes résumées)

1. Définir le problème en termes de comportement (qui doit faire quoi, où, quand).
2. Choisir le comportement cible le plus prometteur.
3. Le décrire précisément.
4. Identifier ce qui doit changer à l'aide de COM-B (diagnostic).
5. Choisir les fonctions d'intervention adaptées.
6. Choisir les catégories de politiques mobilisables.

7. Choisir les techniques de changement de comportement.
8. Choisir le mode de mise en œuvre (face-à-face, groupe, numérique, affichage).

À vous de jouer – Exercice d'application 3.27

Dans une résidence étudiante, le diagnostic montre que les étudiants mangent peu de légumes : ils disent ne pas savoir les cuisiner (1), la cuisine collective n'a qu'une plaque qui fonctionne (2), et « personne ne cuisine ici, on commande » (3). a) Classez chaque frein dans une composante de COM-B. b) Proposez une fonction d'intervention et une technique de changement de comportement pour chacun. c) Quelle catégorie de politique relève du gestionnaire de la résidence ?

Corrigé

a) (1) **Capacité physique** (savoir-faire) et psychologique ; (2) **opportunité physique** ; (3) **opportunité sociale** (norme du groupe), qui joue aussi sur la motivation automatique. **b)** (1) **Formation** : atelier « légumes en 15 minutes » ; techniques : démonstration du comportement, répétition et entraînement. (2) **Restructuration de l'environnement** et **facilitation** : réparer les plaques, fournir des ustensiles ; technique : restructuration de l'environnement physique. (3) **Modélisation** et soutien social : soirées « cuisine partagée » animées par des étudiants relais ; techniques : soutien social pratique, démonstration par des pairs. **c)** La **prestation de services** et l'**aménagement de l'environnement** (équipement de la cuisine, organisation de soirées) relèvent du gestionnaire.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 3.3.12 et 3.3.13 – Mesurer, et le modèle COM-B

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi mélange-t-on des affirmations positives et négatives dans une échelle de Likert ?
2. Dans une analyse prototypique, comment repère-t-on le noyau central probable ?
3. Distinguez validité et fidélité d'un outil de mesure.
4. Citez les trois composantes du modèle COM-B et leurs deux sous-composantes.
5. Citez cinq des neuf fonctions d'intervention de la roue du changement.
6. Combien de techniques compte la taxonomie de Michie (2013) ? À quoi sert-elle ?

Corrigé – Point d'étape 3.3.12 et 3.3.13

1. Pour limiter les réponses automatiques (tout cocher « d'accord ») ; on inverse les items négatifs avant le calcul.
2. Les mots à la fois fréquents (au-dessus du seuil de fréquence) et cités tôt (rang moyen inférieur au rang moyen général).
3. Validité : l'outil mesure bien ce qu'il prétend mesurer. Fidélité : il donne des résultats stables et cohérents.
4. Capacité (physique, psychologique), opportunité (physique, sociale), motivation (réflexive, automatique).
5. Éducation, persuasion, incitation, coercition, formation, restriction, restructuration de l'environnement, modélisation, facilitation.
6. 93 techniques en 16 groupes ; elle sert à décrire précisément le contenu d'une intervention et à comparer les interventions.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.

Mon score	Ce que je fais
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

3.3.14 Adapter l'approche psychosociale aux publics

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M5 S3 (p. 40 à 43) ; Synthèse M5 S4 (p. 44 à 46)

Public	Spécificités psychosociales	Leviers
Jeunes enfants (3-6 ans)	Néophobie, imitation, besoin de répétition et de jeu, dépendance aux adultes	Exposition répétée sans pression, éducation sensorielle, modèles adultes, implication des parents
Enfants (6-11 ans)	Curiosité, besoin de compétence, influence de l'école et des pairs	Activités pratiques, défis, jardinage, cuisine, valorisation
Adolescents	Autonomie, identité, appartenance au groupe, image corporelle, sensibilité au marketing	Pair-éducation, littératie critique, choix, pas de moralisation, vigilance TCA
Jeunes adultes, étudiants	Première autonomie alimentaire, budget, temps, isolement	Cuisine rapide et économique, convivialité, numérique accompagné
Parents	Préoccupation pour les enfants, culpabilité possible, contraintes de temps et de budget	Valoriser leurs compétences, solutions pratiques, déculpabiliser
Personnes âgées	Perte d'appétit, deuil, isolement, habitudes anciennes, peur de la dépendance	Lien social, plaisir, respect des habitudes, enrichissement, repérage de la dénutrition
Personnes en précarité	Priorités de survie, stress, honte, méfiance envers les institutions, faible pouvoir d'agir	Accueil inconditionnel, gratuité, concret, participation, pas de jugement, orientation vers les droits
Personnes migrantes	Acculturation, langue, attachement aux plats d'origine, nouveaux produits	Interculturalité, valorisation des cuisines d'origine, interprétariat, pictogrammes
Personnes en situation de handicap	Besoins spécifiques (cognitifs, moteurs, sensoriels), dépendance à l'entourage	FALC, adaptation du matériel, implication des aidants et des éducateurs

À vous de jouer – Exercice d'application 3.28

Un groupe de parole avec des parents d'adolescents révèle : « Mon fils mange tout le temps des chips devant ses jeux vidéo » ; « Ma fille ne mange plus le soir, elle veut maigrir » ; « Ils achètent des boissons énergisantes avec leur argent de poche ». Analysez chaque situation avec COM-B et proposez une fonction d'intervention.

Corrigé

a) Chips devant les jeux : **motivation automatique** (habitude, grignotage associé à l'écran) et **opportunité physique** (chips disponibles à la maison) → **restructuration de l'environnement** (collations disponibles : fruits, fromage, pain ; pas de stock de chips) et habitudes (pause collation hors écran). **b)** Restriction pour maigrir : **motivation réflexive** (désir de minceur, normes corporelles) avec risque de TCA → pas d'intervention éducative ciblée sur le poids ; **orientation** vers l'infirmière scolaire ou le médecin, travail des parents sur la non-stigmatisation et le plaisir du repas familial (chapitres 4 et 6). **c)** Boissons énergisantes : **opportunité sociale** (normes du groupe, marketing) et **motivation automatique** → **modélisation** et **persuasion** par des pairs, littératie critique du marketing, alternatives appréciées (eaux aromatisées maison).

Le développement de la personne, de l'enfance à la vieillesse

La **psychologie du développement** étudie l'évolution psychologique de la personne tout au long de la vie, de la période fœtale au vieillissement : développement moteur, cognitif, du langage, de l'identité, affectif et social.

Courant	Auteur repère	Idée principale
Maturationniste	Arnold Gesell	Le développement suit surtout un programme biologique
Béhavioriste	John B. Watson	L'environnement et les apprentissages façonnent le comportement
Psychanalytique	Sigmund Freud	Les relations et les expériences de l'enfance construisent le psychisme
Éthologique	Harry Harlow, John Bowlby	Le besoin de contact et d'attachement est inné, indépendant de la faim
Cognitivo-constructiviste	Jean Piaget	L'enfant construit son intelligence en agissant ; la maturation est nécessaire mais pas suffisante
Psychosocial	Henri Wallon	Aspects cognitifs, affectifs et sociaux sont liés

Aujourd'hui, la plupart des chercheurs ont une vision **modulaire** : chaque fonction (mémoire, langage, émotions, relations) a son propre rythme, et la prise en charge cherche les différents facteurs en cause.

- **Stades de Piaget** : sensori-moteur (0 à 2 ans), préopératoire (2 à 7 ans), opératoire concret (7 à 11 ans), opératoire formel (à partir de 11-12 ans).
- **Stade du miroir** (Jacques Lacan, 1936 et 1949), entre 6 et 18 mois environ : l'enfant prend son reflet pour un autre enfant (le **réel**), puis comprend que c'est une image (l'**imaginaire**), enfin la reconnaît comme la sienne (le **symbolique**). Il se distingue de sa mère et construit son **schéma corporel**.
- **Relation mère-enfant** (Winnicott) : dépendance absolue (premiers mois), dépendance relative, puis marche vers l'indépendance.
- **Adolescence** : remaniement biologique, psychique et social ; prise de distance avec les parents ; recours possible au passage à l'acte ou à l'idéalisation.
- **Adulte et personne âgée** : l'intelligence générale change peu jusqu'à 60 ou 70 ans ; la vitesse diminue, mais la **plasticité** permet d'apprendre à tout âge. Avec l'âge, la vulnérabilité augmente et l'adaptation devient plus difficile.

> **Lien diététique – Adapter l'éducation nutritionnelle à l'âge**
>
> Avant 7 ans, on passe par les sens, le jeu et la répétition ; entre 7 et 11 ans, par des manipulations concrètes (trier, peser, cuisiner) ; à partir de 12 ans, on peut discuter de notions abstraites et d'arguments ; chez l'adolescent, on respecte le besoin d'autonomie et le rôle des pairs ; chez la personne âgée, on s'appuie sur l'expérience et on laisse du temps.

La maladie, le stress et la fin de vie

- Le **diagnostic** change le statut de la personne (« je suis diabétique ») et peut bouleverser son équilibre psychique et social.
- L'approche **psychosomatique** (du grec *psyché*, l'esprit, et *soma*, le corps) étudie l'influence de l'esprit sur le corps.
- **Stress** : Hans Selye (1936) décrit le **syndrome général d'adaptation** en trois phases : **alarme** (adrénaline, cœur et respiration accélérés), **résistance** (cortisol, mobilisation du glucose), **épuisement** si le stress dure. Sur le plan digestif : « boule au ventre », nausées, troubles du transit, et souvent changement de l'appétit.
- **Faire face** (*coping*, Lazarus et Folkman, 1984) : agir sur la **cause** du stress (stratégie centrée sur le problème) ou réguler ses **émotions** (stratégie centrée sur l'émotion).

- **La mort** : autrefois à domicile et entourée de rites, elle se déroule aujourd'hui surtout à l'hôpital ; elle est plus « cachée ».

Lien diététique – Le rôle du diététicien auprès des malades et en fin de vie

Prendre conscience de ses propres représentations de la maladie et de la mort ; écouter les peurs et les souffrances de la personne ; en soins palliatifs, l'objectif n'est plus de corriger un état nutritionnel mais de préserver le **confort** et le **plaisir** de manger, en respectant les choix du patient et de ses proches.

3.3.15 Concevoir une séance qui développe les compétences psychosociales en nutrition

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

Les compétences psychosociales (3.3.5) se développent par des **activités expérientielles** structurées, répétées sur plusieurs séances, et non par un discours. Santé publique France (2022) recommande des programmes d'au moins une dizaine de séances, conduits par des intervenants formés, avec des méthodes interactives. Une séance « nutrition » peut cibler explicitement une ou deux CPS.

Exemple – Conducteur d'une séance CPS « Je choisis mon goûter » (élèves de CM1, 1 h 15)

Durée	Étape et CPS visée	Déroulement	Matériel
10 min	Accueil – conscience de soi	Météo des émotions : chaque élève place son prénom sur un visage (content, fatigué, inquiet…) ; on explique que la faim et les émotions peuvent se confondre	Affiche des émotions
15 min	Ressentir – conscience de soi	Échelle de la faim (chapitre 4) : chaque élève situe sa faim avant le goûter ; échange sur « faim » et « envie »	Échelle illustrée
20 min	Analyser – pensée critique	Par groupes, comparaison de 4 emballages de goûters : ce que dit la publicité, ce que dit l'étiquette (sucres en morceaux de sucre)	Emballages, morceaux de sucre
15 min	Décider – prise de décision	Chaque groupe compose un goûter « qui donne de l'énergie, qui fait plaisir, qui coûte peu » parmi des cartes-aliments, et justifie son choix	Cartes-aliments, prix
10 min	Communiquer – affirmation de soi	Jeu de rôle : refuser poliment une boisson sucrée proposée par un camarade, proposer une alternative	Scénarios
5 min	Bilan – conscience de soi	« Ce que j'ai appris, ce que je ferai » ; feuille d'engagement facultative	Fiches

Pourquoi cette séance travaille des CPS : les élèves identifient leurs émotions et sensations (compétences **cognitives et émotionnelles** : conscience de soi), exercent leur **pensée critique** face au marketing, prennent une **décision** argumentée en groupe et s'**affirment** face à la pression des pairs (compétences **sociales**). La séance s'inscrit dans un **programme** (plusieurs séances) mené avec l'enseignant, et non dans une intervention isolée.

Attention – Ce qui n'est pas une séance CPS

Une conférence sur l'équilibre alimentaire, un quiz de connaissances ou une distribution de dépliants ne développent pas de compétences psychosociales : ils transmettent des informations. Une séance CPS fait **vivre** et **pratiquer** une compétence (identifier, analyser, décider, dire non, coopérer), dans un climat bienveillant, avec un temps de retour sur l'expérience.

3.3.16 Fil rouge : les représentations et les dynamiques du groupe des Tilleuls

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès a observé et comment elle l'a utilisé

- **Représentations recueillies** (photolangage « bien manger pour moi », 8 parents) : « bien manger = de la viande tous les jours » (noyau central fortement partagé) ; « les légumes coûtent cher » ; « les lentilles, c'est pour les gens pauvres » (représentation dévalorisante) ; « cuisiner prend du temps ».
- **Usage** : Inès n'a pas contredit ces représentations ; elle a agi sur les éléments **périphériques** : montrer un plat complet sans viande apprécié de tous (parmentier de lentilles, 4,3/5 en dégustation), calculer ensemble le coût par portion (1,38 € le repas complet), proposer des recettes de 20 minutes.
- **Dynamique de groupe** : une participante, Mme D., très appréciée, a goûté la première le dahl de lentilles (influence d'un « leader » positif) ; les autres ont suivi (conformisme favorable).
- **Engagement** : à la fin de chaque atelier, chacun choisissait librement une recette à refaire et l'annonçait au groupe ; à l'atelier suivant, les essais étaient valorisés.
- **CPS travaillées** : prise de décision (menu à 10 €), communication (cuisiner en binôme), estime de soi (photos des plats exposées au centre social, avec accord).
- **Interculturalité** : l'atelier 6 « recettes du monde » a permis à trois mères de transmettre un plat de leur pays (tiep, chorba, dal) : valorisation identitaire et stratégie d'**intégration**.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Compléments : mesures et animation du groupe des Tilleuls

- **Évocation hiérarchisée** : en complément du photolangage, Inès a recueilli les mots associés à « manger équilibré » auprès de **30 parents** lors de la passation du questionnaire (analyse détaillée en 3.3.12 : noyau central probable « cher », « légumes », « santé »). Les deux méthodes convergent : la question du **coût** est centrale, et la **viande** reste, pour beaucoup, la marque d'un « vrai repas ».
- **Score d'attitude** envers les légumes secs (échelle de Likert à 5 items, sur 100) : moyenne des 12 participants **48/100** au 1er atelier, **74/100** au 6e (+ 26 points) ; l'item « difficiles à cuisiner » est celui qui a le plus progressé, ce qui confirme l'effet des ateliers pratiques sur le **sentiment d'efficacité personnelle**.
- **Étapes du groupe** : l'atelier 2 a connu une phase de **turbulence** (désaccord sur le partage des tâches et sur l'usage du téléphone) ; Inès a proposé au groupe d'établir lui-même ses règles (« téléphone en silencieux, chacun goûte s'il le souhaite, on range ensemble ») : **normalisation** dès l'atelier 3 ; à l'atelier 5, deux mamans ont animé seules la préparation du crumble (**production**) ; l'atelier 6 et le temps fort ont préparé la **dissolution** (bilan, suite avec les mamans relais).
- **Style d'animation** : participatif pour les contenus (choix des recettes du monde), directif pour le cadre (hygiène, sécurité au four).
- **Écoute active** : face à une mère répétant « mes enfants ne mangent que des pâtes », Inès a d'abord reformulé (« c'est décourageant ») avant de proposer, avec le groupe, des « pâtes cachées aux légumes » : la mère a refait la recette deux fois.

3.3.17 Trois cas guidés pour s'entraîner à l'analyse psychosociale

Module · Référentiel et guide : voir 3.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 3.2.2)

Ces trois cas reprennent les notions du chapitre dans l'ordre où le jury les attend : décrire la situation, la relier à un modèle, calculer et lire des indicateurs, puis proposer une action argumentée. Essayez de répondre avant de lire chaque corrigé.

Cas guidé 1 – L'épicerie solidaire de Montclair (données fictives)

Une épicerie solidaire accueille 120 foyers. La conseillère en économie sociale et familiale constate que les

légumes frais proposés à petit prix partent mal. Elle sollicite un diététicien. Un questionnaire est rempli par **40 bénéficiaires** volontaires.

- Étapes du changement pour « cuisiner des légumes frais au moins 4 fois par semaine » : précontemplation 10 ; contemplation 14 ; préparation 8 ; action 5 ; maintien 3.
- Scores moyens (échelle de 1 à 5) : attitude envers les légumes 4,1 ; norme subjective 3,6 ; intention 3,0. Contrôle perçu, trois items : « J'ai le temps de les cuisiner » 2,6 ; « J'ai le matériel nécessaire » 2,4 ; « Je sais comment les cuisiner » 1,6.
- Verbatims : « Les légumes, je ne sais pas quoi en faire à part la soupe » ; « Mes enfants veulent des frites » ; « Chez moi, il n'y a qu'une plaque électrique ».

Questions – Cas guidé 1

1. Calculez la répartition des 40 bénéficiaires selon les étapes du changement et le score moyen de contrôle perçu.
2. Interprétez les résultats avec la théorie du comportement planifié.
3. Analysez la situation avec le modèle COM-B.
4. Proposez deux actions, en précisant les fonctions d'intervention et l'étape du changement visée.

Corrigé – Cas guidé 1

1. Précontemplation 10 / 40 = **25,0 %** ; contemplation 14 / 40 = **35,0 %** ; préparation 8 / 40 = **20,0 %** ; action 5 / 40 = **12,5 %** ; maintien 3 / 40 = **7,5 %**. Contemplation et préparation réunissent 22 personnes, soit **55,0 %** : plus de la moitié du groupe envisage de changer sans être passée à l'action. Contrôle perçu moyen : (2,6 + 2,4 + 1,6) / 3 = 6,6 / 3 = **2,2 sur 5**.

2. L'**attitude** est favorable (4,1) et la **norme subjective** plutôt favorable (3,6), mais le **contrôle perçu** est faible (2,2), surtout pour le savoir-faire (1,6). Selon Ajzen, le contrôle perçu limite l'intention (3,0, moyenne) et agit aussi directement sur le comportement : informer sur les bienfaits des légumes (attitude) serait inutile, puisque les bénéficiaires en sont déjà convaincus.

3. **Capacité physique et psychologique** insuffisante (« je ne sais pas quoi en faire ») ; **opportunité physique** limitée (une seule plaque, peu de matériel) ; **opportunité sociale** en partie défavorable (préférences des enfants) ; **motivation réflexive** plutôt favorable ; **motivation automatique** orientée par les habitudes (frites, soupe).

4. Action 1 : **atelier culinaire** « légumes avec une seule plaque » (poêlées, légumes râpés, gratins au four de l'épicerie si possible) : fonctions **formation** et **facilitation** ; techniques : démonstration, répétition, plan « si…, alors… » ; public visé : étapes de **contemplation** et de **préparation**. Action 2 : **dégustations** à l'épicerie avec fiches-recettes illustrées et prêt d'ustensiles, enfants invités à participer : fonctions **modélisation**, **restructuration de l'environnement** et facilitation ; elle touche aussi les personnes en **précontemplation**, sans exiger d'engagement.

Cas guidé 2 – Une séance qui dérape (extrait)

Lors de la deuxième séance d'un cycle avec 10 parents d'un quartier prioritaire, une animatrice stagiaire aborde les boissons sucrées. Voici un extrait de l'échange.

1. **Animatrice** : « Qui boit du soda à la maison ? »
2. **M. B.** : « Nous, tous les jours. Les enfants adorent. »
3. **Animatrice** : « Ce n'est vraiment pas bien, un litre de soda contient environ 100 grammes de sucre. »
4. **Mme L.** : « Oui mais l'eau du robinet, chez nous, elle a un goût. »
5. **Animatrice** : « Vous pouvez la mettre au frigo dans une carafe, c'est simple. Et vous savez que c'est mauvais pour les dents ? »

6. M. B. : « De toute façon, on a toujours fait comme ça et personne n'est malade. »
7. Mme T. (qui ne parlait pas) : « Moi j'ai arrêté les sodas, je fais de l'eau avec du citron. »
8. Animatrice : « Très bien ! Voilà, vous voyez, c'est possible. »
9. M. B. se tait et regarde son téléphone jusqu'à la fin.

Questions – Cas guidé 2

1. Identifiez l'attitude de Porter utilisée en 3 et en 5.
2. Quel phénomène décrit par l'entretien motivationnel se produit entre 3 et 6 ? Comment se manifeste-t-il ?
3. À quelle étape de la vie du groupe sommes-nous ? Le désaccord est-il un problème ?
4. Comptez les questions et les reflets de l'animatrice et calculez le rapport reflets / questions. Commentez.
5. Réécrivez les répliques 3, 5 et 8 dans l'esprit de l'entretien motivationnel.

Corrigé – Cas guidé 2

1. En 3 : **évaluation** (jugement : « ce n'est vraiment pas bien ») suivie d'une information non demandée. En 5 : **solution** (conseil immédiat), puis question fermée orientée qui sonne comme un nouveau jugement.

2. Le **réflexe correcteur** de l'animatrice provoque la **résistance** et le **discours-maintien** (« de toute façon, on a toujours fait comme ça ») ; M. B. finit par se retirer de l'échange (réplique 9), ce qui est aussi une forme de résistance. Plus l'animatrice argumente pour le changement, plus le parent défend le statu quo.

3. Deuxième séance : fin de la **formation** et début de la **turbulence** (Tuckman). Le désaccord est **normal** et signe l'implication ; le problème vient de la façon dont il est traité (jugement), qui risque de faire perdre un participant.

4. Questions : répliques 1 et 5, soit **2** questions. Reflets : **aucun** (la réplique 8 est une valorisation, pas un reflet). Rapport reflets / questions = 0 / 2 = **0** : très loin du repère d'au moins 1 (MITI 4). L'animatrice informe et juge au lieu d'écouter.

5. Réplique 3 : « Les sodas font partie des habitudes de la famille, les enfants y sont attachés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? » Réplique 5 : « Le goût de l'eau vous gêne. Voulez-vous que je vous donne quelques idées que d'autres familles utilisent ? » (demander la permission, puis informer). Réplique 8 : valoriser sans opposer : « Merci, Mme T. Vous avez trouvé votre façon de faire. Chaque famille a ses habitudes ; qu'est-ce qui pourrait être faisable chez vous, même un petit peu ? », en s'adressant au groupe et non à M. B. seul.

Cas guidé 3 – Évaluer un cycle d'ateliers en résidence autonomie (données fictives)

Une diététicienne anime un cycle de 6 ateliers sur 3 mois avec 10 résidents d'une résidence autonomie. L'objectif est de favoriser un **dîner complet** (avec une source de protéines), car beaucoup de résidents se contentent d'une soupe ou d'un café au lait le soir. Avant le premier et après le dernier atelier, chaque résident répond à une échelle de Likert de 5 items (score de 5 à 25) sur son attitude envers le dîner complet, et indique son étape du changement.

- Scores avant : 12, 15, 9, 18, 11, 14, 16, 10, 13, 17.
- Scores après : 17, 18, 15, 19, 12, 20, 21, 11, 18, 22.
- Étapes avant : précontemplation 3, contemplation 4, préparation 2, action 1, maintien 0.
- Étapes après : précontemplation 1, contemplation 2, préparation 3, action 4, maintien 0.

Questions – Cas guidé 3

1. Calculez le score moyen avant et après, son évolution, et les scores moyens ramenés sur 100.
2. Calculez la médiane avant et après. Combien de résidents ont progressé de plus de 1 point ?

3. Décrivez l'évolution des étapes du changement. Pourquoi aucun résident n'est-il au stade du maintien ?

4. Citez quatre limites de cette évaluation.

Corrigé – Cas guidé 3

1. Somme avant : 135, moyenne **13,5** ; somme après : 173, moyenne **17,3** ; évolution **+3,8 points**. Sur 100 : avant (13,5 − 5) / 20 × 100 = **42,5** ; après (17,3 − 5) / 20 × 100 = **61,5** ; soit **+19 points** sur 100.

2. Scores avant rangés : 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ; médiane = (13 + 14) / 2 = **13,5**. Scores après rangés : 11, 12, 15, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22 ; médiane = (18 + 18) / 2 = **18,0**. Les écarts individuels sont 5, 3, 6, 1, 1, 6, 5, 1, 5, 5 : les 10 résidents ont progressé, mais **3** seulement de 1 point ; **7 sur 10** ont progressé de plus de 1 point.

3. Les personnes en précontemplation passent de 3 à 1 et celles en action de 1 à 4 : le groupe a globalement **avancé** dans le cycle. Aucun résident n'est en **maintien**, car ce stade suppose un changement installé depuis **plus de 6 mois** et le cycle n'a duré que 3 mois ; il faudra une nouvelle mesure à 6 mois au moins.

4. Effectif très faible (10 personnes) : on parle de **tendances** ; **pas de groupe témoin** (l'évolution pourrait être due à autre chose, par exemple un changement de menu à la résidence) ; **désirabilité sociale** (les résidents peuvent répondre ce qu'ils pensent que la diététicienne attend) ; mesure de l'**attitude** et de l'étape déclarée, pas du comportement réel (il faudrait un relevé des dîners) ; pas de recul sur la durée.

3.4 Approfondissements

3.4.1 Néophobie alimentaire et exposition répétée

La **néophobie alimentaire** (réticence à goûter des aliments nouveaux) est maximale entre 2 et 6 ans ; elle est normale et adaptative (protection contre les aliments dangereux). Elle diminue avec l'**exposition répétée** : proposer un aliment 8 à 15 fois, sans pression, en petites quantités, dans un contexte agréable, augmente son acceptation. La **pression** (« finis ton assiette ») et la **récompense** par un dessert (« si tu manges tes légumes, tu auras un gâteau ») sont contre-productives : elles dévalorisent l'aliment cible et valorisent l'aliment récompense. Le modèle parental (manger soi-même les légumes) et l'**éducation sensorielle** (toucher, sentir, décrire) sont efficaces.

Exemple – Exposition ou récompense ? (Wardle et collaborateurs, 2003)

Des enfants de 5 à 7 ans ont goûté chaque jour, pendant 8 jours, un légume qu'ils aimaient peu (du poivron rouge cru). Un groupe le goûtait simplement (exposition) ; un autre recevait un autocollant à chaque fois (exposition et récompense) ; un groupe témoin ne le goûtait pas. L'appréciation et la quantité consommée ont augmenté dans le groupe **exposition seule** ; l'ajout de la récompense n'a pas apporté de bénéfice supplémentaire clair. **Leçon** : la répétition, sans pression et sans récompense, suffit ; la récompense n'est pas nécessaire et peut même nuire à long terme (effet de surjustification, section 3.3.11).

Définition – Néophobie et sélectivité alimentaire

- La **néophobie** est le refus des aliments **nouveaux** ou inconnus.
- La **sélectivité** (en anglais *picky eating*) est le refus d'une partie des aliments **familiers**, avec un répertoire alimentaire restreint.

Les deux sont fréquentes chez le jeune enfant et diminuent en général avec l'âge. Une sélectivité très marquée, avec perte de poids, retard de croissance ou détresse importante, doit faire penser à un trouble (par exemple le trouble d'évitement et de restriction de l'apport alimentaire, ARFID) et justifie une **orientation** médicale.

Calcul détaillé – L'échelle de néophobie alimentaire de Pliner et Hobden (1992)

L'échelle comporte **10 affirmations** notées de 1 (« pas du tout d'accord ») à 7 (« tout à fait d'accord »). Cinq affirmations expriment la néophobie (« Je n'aime pas les aliments que je ne connais pas ») ; cinq expriment l'ouverture (« J'aime goûter des aliments d'autres pays »). Les affirmations d'ouverture sont inversées (score inversé = 8 − réponse). Le score total va de **10 à 70** : plus il est élevé, plus la personne est néophobe.

Réponses de M. R., 45 ans, à un questionnaire d'atelier : items néophobes 6, 5, 6, 4, 5 (total **26**) ; items d'ouverture 2, 3, 1, 3, 2, inversés en 6, 5, 7, 5, 6 (total **29**).

- Score total : 26 + 29 = **55 sur 70**.
- Position sur l'étendue : (55 − 10) / (70 − 10) × 100 = 45 / 60 × 100 = **75 / 100**.

Lecture : M. R. est plutôt néophobe. Dans l'atelier, on lui propose de goûter en petite quantité, avec un aliment familier à côté, et on présente les nouveautés à partir de saveurs connues (épices douces, plats de son enfance revisités).

Méthode pas à pas – Organiser une exposition répétée en crèche ou à l'école

1. Choisir un aliment cible (un légume peu consommé) et prévoir **8 à 15** présentations.
2. Le proposer en **petite quantité**, à côté d'aliments connus, sous la même forme au début.
3. Laisser l'enfant le **toucher**, le sentir, le décrire, le recracher dans une serviette s'il le souhaite.
4. Montrer l'exemple : l'adulte en mange avec plaisir à la même table.
5. Ne jamais forcer, ne pas récompenser, ne pas punir ; féliciter simplement la curiosité.
6. Noter à chaque fois l'acceptation (refus, touche, goûte, mange) pour voir la progression et rassurer l'équipe et les parents.

3.4.2 Les normes sociales comme levier

Les campagnes fondées sur les **normes descriptives** (« 8 élèves sur 10 de ce collège boivent de l'eau à la récréation ») peuvent être plus efficaces que les injonctions, à condition que la norme présentée soit favorable et **vraie** : diffuser « 60 % des jeunes boivent des sodas tous les jours » risque au contraire de **normaliser** le comportement à éviter (effet boomerang).

Exemple – L'effet boomerang des normes descriptives (Schultz et collaborateurs, 2007)

Près de 300 foyers californiens ont reçu une information sur leur consommation d'électricité comparée à la moyenne de leur quartier (norme **descriptive**). Les foyers qui consommaient **plus** que la moyenne ont réduit leur consommation. Mais ceux qui consommaient **moins** l'ont augmentée : ils se sont rapprochés de la norme (effet **boomerang**). Lorsqu'on ajoutait un petit visage souriant pour les foyers économes (norme **injonctive** : approbation), l'effet boomerang disparaissait.

En nutrition : dire à des familles qui servent déjà des légumes chaque jour que « la moyenne des familles en sert 3 fois par semaine » peut les inciter à en servir moins. On associe toujours la norme descriptive à une **approbation** (« Bravo, vous faites partie des familles qui… »).

Exemple – Le parc de la forêt pétrifiée (Cialdini, 2003)

Dans un parc national américain, des visiteurs emportaient des morceaux de bois fossilisé. Un panneau indiquant que « de nombreux visiteurs ont emporté du bois pétrifié » (norme descriptive négative) a été associé à **7,92 %** de vols dans la zone test, contre **1,67 %** avec un panneau demandant simplement de ne pas emporter de bois (norme injonctive). **Leçon** : un message qui insiste sur le fait que « beaucoup de gens font le mauvais choix » rend ce choix normal. Les campagnes qui répètent que « la majorité des jeunes ne mangent

pas assez de fruits » risquent le même effet.

Méthode pas à pas – Construire un message fondé sur les normes sociales

1. Mesurer la pratique réelle du public (enquête, chapitre 18) et la **norme perçue** (« Selon vous, combien d'élèves de votre classe boivent de l'eau à la récréation ? »).
2. Repérer l'écart : le public surestime souvent les comportements défavorables de ses pairs.
3. Diffuser la pratique **réelle et favorable** (« 7 élèves sur 10 de ce collège boivent de l'eau à la récréation »), avec une source.
4. Ajouter une **approbation** et un moyen d'agir (« Des fontaines sont à votre disposition dans la cour »).
5. Évaluer : la norme perçue et la pratique ont-elles changé ?

À vous de jouer – Exercice d'application 3.29

Dans un lycée, une enquête montre que 62 % des élèves prennent un petit-déjeuner tous les jours, mais que les élèves pensent en moyenne que seulement 30 % de leurs camarades le font. Une affiche est en préparation : « Près de 4 lycéens sur 10 ne prennent pas de petit-déjeuner ! ». a) Quel est le risque de cette affiche ? b) Proposez un autre message. c) Quel indicateur suivre pour évaluer la campagne ?

Corrigé

a) Elle met en avant une norme descriptive **défavorable** (38 % sans petit-déjeuner) et renforce la fausse croyance que sauter le petit-déjeuner est courant : risque d'effet boomerang. **b)** « 6 lycéens sur 10 commencent la journée par un petit-déjeuner. Et vous ? Des idées rapides au foyer du lycée » (norme réelle, favorable, avec un moyen d'agir). **c)** La **norme perçue** (pourcentage estimé de camarades qui prennent un petit-déjeuner, qui devrait se rapprocher de 62 %) et la **pratique déclarée** avant et après la campagne.

3.4.3 L'influence des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux participent désormais à la socialisation alimentaire des jeunes : influenceurs promouvant des produits ou des régimes, images corporelles retouchées, défis alimentaires. Développer la **pensée critique** (CPS) et l'**éducation aux médias** fait partie de l'éducation pour la santé. Le diététicien, lorsqu'il communique lui-même sur les réseaux, veille à son **identité numérique** et à l'indépendance de ses messages (chapitre 15).

À retenir – Ce que dit la loi française

- Depuis le **1er octobre 2017** (décret n° 2017-738 du 4 mai 2017), les photographies publicitaires dont la silhouette d'un mannequin a été modifiée par logiciel doivent porter la mention « **photographie retouchée** ».
- La **loi n° 2023-451 du 9 juin 2023** encadre l'influence commerciale sur les réseaux sociaux : l'influenceur doit signaler clairement le partenariat (« publicité » ou « collaboration commerciale ») et indiquer « **image retouchée** » ou « **image virtuelle** » quand un visage ou une silhouette ont été modifiés ou créés par un logiciel. Elle interdit notamment la promotion de la chirurgie esthétique et de pratiques qui détournent des soins.

Mécanisme psychosocial	Sur les réseaux sociaux	Ce que l'on peut travailler en atelier
Comparaison sociale (Festinger, 1954)	On se compare à des images sélectionnées, retouchées et filtrées	Comparer une photo « avant » et « après » retouche ; parler de mise en scène
Identification au modèle (Bandura)	L'influenceur paraît proche et sincère, comme un ami	Repérer les partenariats commerciaux et les codes promotionnels

Mécanisme psychosocial	Sur les réseaux sociaux	Ce que l'on peut travailler en atelier
Preuve sociale	Nombre de « j'aime » et de vues	Rappeler que la popularité ne prouve pas la véracité
Algorithme et bulle	Plus on regarde des contenus « minceur », plus on en reçoit	Montrer comment varier son fil, se désabonner, signaler
Biais de confirmation	On croit ce qui conforte nos idées	Vérifier une information sur deux sources fiables (chapitre 19)

Méthode pas à pas – Analyser une publication d'influenceur avec des adolescents

1. **Qui parle ?** Un professionnel de santé, une marque, un particulier ? A-t-il un intérêt commercial ?
2. **Que vend-on ?** Un produit, un régime, un mode de vie, une image du corps ?
3. **Quelles preuves ?** Une étude citée, un avant-après, un témoignage unique ?
4. **Quelles émotions ?** Envie, peur de manquer, culpabilité, admiration ?
5. **Qu'est-ce qui est absent ?** Le prix, les effets indésirables, la retouche, le sponsoring ?
6. **Qu'est-ce que j'en fais ?** Partager, ignorer, vérifier, en parler ?

À vous de jouer – Exercice d'application 3.30

Une influenceuse suivie par 400 000 abonnés publie une vidéo « Ma détox 3 jours aux jus pour un ventre plat », avec un code promo pour une marque de jus et une photo d'elle avant et après. a) Repérez trois mécanismes psychosociaux mis en jeu. b) Quelles obligations légales doit-elle respecter ? c) Proposez une activité de 20 minutes avec des élèves de seconde.

Corrigé

a) Identification au modèle (proximité, mise en scène de sa vie), **comparaison sociale** (photo avant-après, idéal du « ventre plat »), **preuve sociale** (400 000 abonnés). **b)** Indiquer clairement le partenariat (« publicité » ou « collaboration commerciale ») et la mention « image retouchée » si la photo a été modifiée (loi du 9 juin 2023). **c)** En petits groupes, les élèves appliquent la grille en six questions à la vidéo, puis comparent le prix de la cure à celui de fruits frais et d'eau ; la mise en commun porte sur le message « pour un ventre plat » (aucune base scientifique, corps idéal unique) et sur ce que l'on peut faire (ne pas partager, signaler, en parler).

3.4.4 La pair-éducation et les personnes relais

La **pair-éducation** consiste à confier une partie de l'action éducative à des personnes **du même groupe** que le public (âge, situation, culture) : lycéens ambassadeurs, mamans relais, étudiants relais santé, médiateurs pairs. Elle s'appuie sur la crédibilité et la proximité des pairs (normes sociales, identification) et favorise la participation. Ses conditions de réussite : recrutement volontaire, **formation** des pairs (contenus et posture), accompagnement régulier par un professionnel, reconnaissance (attestation, valorisation), limites claires (le pair n'est pas un professionnel de santé et oriente).

Méthode pas à pas – Monter un projet de pair-éducation en nutrition

1. **Définir le rôle des pairs** : informer ? animer un stand ? accompagner un groupe ? Le rôle reste limité et clair.
2. **Recruter** des volontaires, reconnus par le groupe (et pas seulement les « bons élèves »), avec l'accord des parents s'ils sont mineurs.
3. **Former** sur quelques messages simples, sur la posture (écoute, non-jugement, confidentialité) et sur les limites : savoir orienter vers un adulte ou un professionnel.

4. **Coconstruire** les outils avec les pairs : ils connaissent les codes et le langage du groupe.
5. **Accompagner** : temps de retour réguliers, soutien en cas de difficulté.
6. **Reconnaître** : attestation, valorisation dans le parcours scolaire ou professionnel, rétribution si c'est prévu.
7. **Évaluer** : nombre de pairs formés, actions réalisées, perception du public, effets sur les pairs eux-mêmes (estime de soi, compétences).

Atout de la pair-éducation	Limite ou risque	Réponse
Crédibilité et proximité culturelle	Diffusion de messages inexacts	Formation, supports validés, relecture
Langage adapté	Pression sur le pair, qui devient « le spécialiste »	Rôle limité, soutien d'un professionnel
Effet sur les normes du groupe	Recrutement biaisé (toujours les mêmes)	Recrutement ouvert, diversité des profils
Bénéfices pour les pairs eux-mêmes	Épuisement, départs	Reconnaissance, rotation, binômes

À vous de jouer – Exercice d'application 3.31

Une mission locale veut former 6 jeunes « ambassadeurs de l'alimentation » parmi les jeunes accompagnés. a) Expliquez pourquoi des pairs peuvent être plus efficaces qu'un professionnel, en citant deux notions du chapitre. b) Donnez trois contenus de leur formation. c) Citez deux limites et la façon de les prévenir.

Corrigé

a) Les pairs appartiennent au **groupe de référence** des jeunes : l'**identification** et l'apprentissage par **observation** (Bandura) sont plus forts ; ils font évoluer les **normes** du groupe de l'intérieur ; leur message ne déclenche pas la **menace identitaire** que peut provoquer un discours d'« expert ». **b)** Quelques messages simples sur les repas à petit budget ; l'écoute active (questions ouvertes, reformulation) ; les limites de leur rôle et les adresses vers lesquelles orienter (infirmière, médecin, aide alimentaire). **c)** Messages inexacts : formation et supports validés par le diététicien ; surcharge ou isolement des ambassadeurs : binômes, réunion mensuelle avec un professionnel, reconnaissance (attestation de compétences).

3.4.5 La motivation des enfants et des adolescents

Chez l'**enfant**, l'imitation des adultes et des pairs, l'exposition répétée, le jeu et le plaisir sensoriel priment sur l'information ; les récompenses alimentaires et la pression (« finis ton assiette ») sont contre-productives. Chez l'**adolescent**, la recherche d'**autonomie**, l'appartenance au groupe et l'image de soi dominent : les messages de santé à long terme le touchent peu ; on mise sur l'autonomie (choisir, cuisiner seul), la critique du marketing (« ne pas se faire manipuler »), la performance sportive ou l'énergie, et la participation des jeunes à la conception de l'action.

Le modèle du **partage des responsabilités** d'Ellyn Satter (le parent décide quoi, quand et où ; l'enfant décide s'il mange et combien) est présenté au chapitre 4 (section 4.3.9). La psychologie sociale explique pourquoi certaines stratégies parentales très répandues produisent l'effet inverse de celui recherché : elles agissent sur la **motivation** de l'enfant et sur le **sens** qu'il donne aux aliments.

Stratégie parentale fréquente	Effet probable	Alternative
« Finis ton assiette. »	Apprend à ignorer la sensation de rassasiement	« Tu as encore faim ? » ; servir de petites portions, se resservir si besoin
« Si tu manges tes légumes, tu auras un dessert. »	Le légume devient une corvée, le dessert une récompense	Servir le dessert prévu sans condition ; proposer le légume régulièrement

Stratégie parentale fréquente	Effet probable	Alternative
« Tu ne sortiras pas de table tant que… »	Associe le repas à la contrainte et à la colère	Repas d'une durée raisonnable, sans conflit
Interdire totalement les sucreries	Augmente l'envie et la consommation quand l'aliment est disponible	Les intégrer de façon prévisible (au goûter du mercredi)
Laisser l'enfant choisir tout son repas	Répertoire restreint, conflits	Proposer un choix limité (« carottes ou haricots ? »)

Lien diététique – L'adolescent, entre autonomie et appartenance

Avec les adolescents, on transforme le besoin d'autonomie en levier : leur confier un vrai **rôle** (choisir et cuisiner le repas de la classe, gérer un budget), leur donner des arguments pour **ne pas se faire manipuler** par le marketing, parler des bénéfices **immédiats** (énergie, sport, concentration) plutôt que de la santé dans trente ans, et les associer à la **conception** des actions qui leur sont destinées. On évite toute référence au poids et toute moralisation.

À vous de jouer – Exercice d'application 3.32

Au cours d'un atelier parents-enfants, une mère dit : « Mon fils de 5 ans ne mange rien à table, alors je lui promets des bonbons s'il finit ses haricots. » a) Analysez cette stratégie avec deux notions du chapitre. b) Proposez trois conseils fondés sur le partage des responsabilités. c) Quelle posture adoptez-vous pour formuler ces conseils ?

Corrigé

a) La récompense crée une **motivation extrinsèque** et un effet de **surjustification** : l'enfant apprend que les haricots sont une corvée et les bonbons un trésor ; « finir » l'assiette l'éloigne de ses sensations de **rassasiement**. **b)** Servir de petites portions et laisser l'enfant décider combien il mange ; proposer les haricots régulièrement, sans pression, en en mangeant soi-même (**exposition répétée**, modélisation) ; servir le dessert prévu sans condition et ne pas utiliser les bonbons comme récompense. **c)** Une posture d'**écoute** et de non-jugement : reformuler d'abord la difficulté (« ces repas sont fatigants pour vous »), demander la permission avant d'informer, et s'appuyer sur ce que la mère réussit déjà.

3.4.6 Les émotions dans l'apprentissage

Les émotions **positives** (plaisir, fierté, convivialité) favorisent la mémorisation et l'envie de refaire ; la **peur** et la **honte** peuvent provoquer l'évitement (ne plus venir, ne plus parler). Les messages fondés sur la peur ne sont efficaces que si la personne se sent capable d'agir (sentiment d'efficacité) ; en nutrition, ils sont à éviter auprès des publics vulnérables (stigmatisation, chapitre 6).

Définition – Le modèle des processus parallèles étendu (Witte, 1992)

Face à un message qui fait peur, la personne évalue d'abord la **menace** (est-ce grave ? suis-je concerné ?), puis son **efficacité** (la solution proposée marche-t-elle ? suis-je capable de l'appliquer ?).

- Menace **forte** et efficacité **forte** : la personne cherche à **contrôler le danger** (elle change).
- Menace **forte** et efficacité **faible** : elle cherche à **contrôler sa peur** (déni, évitement, rejet du message, « de toute façon, on mourra tous de quelque chose »).
- Menace **faible** : le message est ignoré.

Conséquence : un message qui fait peur doit toujours être accompagné d'une solution concrète, à la portée de la personne. En nutrition, auprès des publics vulnérables, on préfère les messages positifs.

3.4.7 Précarité alimentaire : honte, dignité et pouvoir d'agir

La précarité ne se réduit pas au manque d'argent : elle a des effets **psychosociaux** qui conditionnent la participation aux actions de prévention.

Effet psychosocial	Manifestation	Conséquence pour l'action
Honte et peur du jugement	Ne pas oser dire qu'on manque, cacher le recours à l'aide alimentaire	Accueil discret, non-jugement, pas de questions intrusives devant le groupe
Stigmatisation	Être vu comme « assisté », « mauvais gestionnaire »	Valoriser les compétences (gérer avec peu est une compétence)
Charge mentale et stress	Préoccupations multiples (logement, dettes), moins de disponibilité pour planifier	Actions courtes, concrètes, peu de prérequis
Préférence pour le présent	Priorité à ce qui est sûr et rassasiant aujourd'hui	Recettes nourrissantes et appréciées, résultats immédiats
Non-recours aux droits	Ne pas demander une aide à laquelle on a droit (complexité, honte, méconnaissance)	Informer sur les droits, orienter, accompagner les démarches avec les travailleurs sociaux
Faible pouvoir d'agir	Sentiment de ne rien pouvoir changer	Participation aux décisions, choix, valorisation des réussites

Lien diététique – Les dispositifs qui préservent la dignité

Les **épiceries solidaires**, où l'on choisit ses produits et où l'on paie une petite participation, sont souvent préférées aux colis imposés, car elles respectent l'**autonomie** et la dignité. Les ateliers culinaires y trouvent toute leur place : ils partent des produits réellement disponibles et valorisent les savoir-faire des personnes.

3.4.8 Le numérique dans l'accompagnement du changement

Applications de suivi alimentaire, objets connectés, groupes de discussion en ligne, vidéos de recettes : le numérique offre de nouveaux outils pour accompagner le changement, avec des atouts et des risques.

Outil	Mécanisme psychosocial	Atout	Risque ou limite
Application de suivi des repas	Auto-surveillance, rétroaction	Prise de conscience, suivi des objectifs	Comptage obsessionnel, culpabilité, données personnelles de santé
Défis et badges (« ludification »)	Récompense, compétition	Motivation à court terme	Motivation externe, abandon rapide
Groupe de messagerie d'un atelier	Soutien social, normes du groupe	Lien entre les séances, partage de photos de plats	Confidentialité, horaires, exclusion des personnes peu équipées
Vidéos de recettes courtes	Modélisation, apprentissage par observation	Accessibles, visuelles, multilingues possibles	Recettes parfois peu réalistes, marketing caché
Téléconsultation de groupe	Accès facilité	Moins de déplacements	Fracture numérique, moindre convivialité

Attention – Numérique et inégalités

Une partie de la population n'a pas d'équipement adapté, de connexion suffisante ou de compétences numériques (illectronisme, chapitre 15). Un dispositif uniquement numérique creuse les inégalités sociales de santé. On propose toujours une alternative non numérique, et l'on respecte les règles de protection des données de santé (RGPD, chapitre 20).

À vous de jouer – Exercice d'application 3.33

Pour prolonger un cycle d'ateliers avec des familles d'un quartier prioritaire, une animatrice veut créer un groupe de messagerie et proposer une application qui attribue des points à chaque repas « équilibré ». a) Quels mécanismes psychosociaux sont mobilisés par chaque outil ? b) Citez deux risques pour chacun. c) Que proposez-vous pour les familles qui n'ont pas de smartphone ?

Corrigé

a) Le groupe de messagerie mobilise le **soutien social** et les **normes** du groupe ; l'application mobilise l'**auto-surveillance** et la **récompense**. **b)** Groupe : diffusion d'informations personnelles (confidentialité) et sollicitations à toute heure ou exclusion de ceux qui sont moins actifs ; application : motivation **externe** qui s'arrête avec les points, culpabilité ou comptage excessif, collecte de données de santé par un éditeur privé. **c)** Une rencontre mensuelle au centre social, des fiches-recettes papier et un affichage dans le hall, pour que personne ne soit exclu.

3.4.9 Les personnes âgées : vieillissement, isolement et plaisir de manger

Avec l'âge, les dimensions psychosociales de l'alimentation prennent une place majeure. Le repas structure la journée, maintient le lien social et l'identité ; sa perte de sens est un facteur de **dénutrition**, qui touche une part importante des personnes âgées vivant à domicile et davantage encore en établissement (HAS et FFAMCO, recommandations sur la dénutrition de la personne âgée, 2021).

Facteur psychosocial	Effet sur l'alimentation	Levier
Veuvage, deuil	Perte de l'envie de cuisiner « pour soi seul », perte du rôle de cuisinier ou absence de savoir-faire chez celui qui ne cuisinait pas	Repas partagés, ateliers « cuisiner pour une personne », soutien et écoute
Isolement social	Repas sautés ou réduits, monotonie	Restaurants seniors, portage de repas avec visite, activités collectives
Dépression	Perte d'appétit et de plaisir	Repérage et orientation vers le médecin
Perte d'autonomie	Difficulté à faire les courses, à porter, à cuisiner	Aide à domicile, livraison, ustensiles adaptés
Représentations	« À mon âge, on n'a plus besoin de manger beaucoup » ; peur du cholestérol ou du sucre héritée de régimes anciens	Information sur les besoins, levée des régimes restrictifs inutiles (avis médical)
Identité et habitudes	Attachement aux plats de toujours, refus de la nouveauté	Partir des plats familiers, valoriser l'expérience culinaire (réminiscence)

Lien diététique – L'atelier de réminiscence culinaire

Un atelier de **réminiscence** invite les personnes âgées à évoquer les plats de leur enfance, les fêtes, les marchés d'autrefois, à partir d'objets, de photos ou d'odeurs, puis à réaliser ensemble une recette d'antan, éventuellement enrichie (fromage, œuf, lait en poudre). Il mobilise l'**identité**, la **mémoire** et le **sentiment de compétence** (« je sais faire »), favorise le lien entre les participants et redonne du sens au repas. Il convient aussi aux personnes ayant des troubles cognitifs légers, avec un rythme adapté.

Attention – Âgisme

Les stéréotypes liés à l'âge (« les vieux ne changent pas », « ils ne comprennent rien au numérique ») sont une forme de **stigmatisation**. Ils conduisent à infantiliser (tutoiement, voix forte, « ma petite dame ») et à moins proposer d'activités. Les personnes âgées peuvent apprendre et changer : on s'adresse à elles comme à

des adultes, on respecte leurs choix et leur rythme.

3.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – La théorie de l'identité sociale (Tajfel et Turner, 1979)

Les individus cherchent une identité sociale positive en se comparant favorablement à d'autres groupes (favoritisme intra-groupe). Les expériences du « paradigme des groupes minimaux » ont montré qu'une catégorisation arbitraire suffit à créer une préférence pour son groupe. En alimentation, les pratiques (végétarisme, « manger local », cuisine d'origine) peuvent devenir des marqueurs de frontière entre groupes ; un message perçu comme venant d'un autre groupe (« les experts », « les bobos ») peut être rejeté pour des raisons identitaires plus que rationnelles.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Habitus et goûts de classe (Bourdieu, 1979)

Pour Pierre Bourdieu, l'**habitus** est un système de dispositions durables, acquis par la socialisation, qui oriente les goûts et les pratiques. Le « goût de nécessité » des classes populaires (aliments nourrissants, abondants, conviviaux) s'oppose au « goût de liberté » des classes favorisées (légèreté, forme, distinction). Ces analyses invitent à ne pas imposer aux classes populaires des normes nutritionnelles qui reflètent les goûts des classes favorisées, mais à partir de leurs propres valeurs (convivialité, générosité du repas).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le paradoxe de l'omnivore et la gastro-anomie (Fischler, 1990)

Le mangeur humain est pris entre **néophilie** (besoin de variété) et **néophobie** (méfiance) ; les cuisines et les règles culturelles résolvent ce paradoxe en encadrant ce qui est mangeable. Dans les sociétés modernes, l'affaiblissement des règles collectives (repas destructurés, offre surabondante, discours contradictoires des experts, des médias et de l'industrie) produit une **gastro-anomie** : le mangeur, laissé seul juge, devient anxieux. Le diététicien peut contribuer à **re-socialiser** l'alimentation (repas partagés, transmission culinaire) plutôt qu'à multiplier les injonctions.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Les limites des modèles individuels du changement

Les modèles HBM, transthéorique ou du comportement planifié expliquent une part limitée des comportements (souvent moins de 30 à 40 % de la variance de l'intention et moins encore du comportement réel). Ils sous-estiment les **habitudes** (comportements automatiques déclenchés par le contexte), les **émotions** et les **déterminants sociaux**. Les approches récentes (modèle COM-B de Michie et coll., 2011 : capacité, opportunité, motivation) intègrent explicitement l'environnement (opportunité) et orientent vers des interventions combinant éducation, modification de l'environnement et incitations.

Pour aller plus loin – niveau L3 – L'identité sociale (Tajfel et Turner, 1979)

La théorie de l'**identité sociale** explique que chacun tire une partie de son estime de soi de son appartenance à des **groupes** et tend à favoriser son groupe (favoritisme endogroupe). En alimentation, les pratiques signalent l'appartenance (« chez nous, on mange comme ça ») : un message perçu comme venant d'un groupe extérieur (« les diététiciens des beaux quartiers ») peut être rejeté pour préserver l'identité. D'où l'intérêt des pairs, de la valorisation des cultures d'origine et des recettes construites **avec** les participants.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Goût de nécessité et goût de liberté (Bourdieu, 1979)

Dans *La Distinction* (1979), Pierre Bourdieu montre que les goûts alimentaires sont socialement construits par l'**habitus** : les classes populaires valorisent un **goût de nécessité** (nourriture abondante, consistante, qui « tient au corps », convivialité), les classes favorisées un **goût de liberté** (légèreté, forme, raffinement, santé). Les messages nutritionnels, souvent produits par des professionnels issus des classes moyennes et supérieures, risquent d'imposer implicitement une norme de classe. Le diététicien gagne à reconnaître la légitimité de ces goûts (repas copieux et conviviaux) et à construire l'équilibre **à partir** d'eux.

3.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Consultation et étape du changement

Un patient diabétique dit : « De toute façon, je n'y arriverai jamais. » Le diététicien repère un faible **sentiment d'efficacité personnelle** et une étape de **contemplation** ; il fixe avec lui un objectif très accessible (expérience de réussite) et utilise les techniques de l'entretien motivationnel.

Situation bc2 – Introduire un nouveau plat en restauration scolaire

Un plat de légumineuses est refusé par les élèves. En s'appuyant sur la néophobie et l'exposition répétée, le diététicien propose de le servir régulièrement en petite quantité, de l'accompagner d'une animation (dégustation, nom attractif, implication d'élèves ambassadeurs) et d'observer le gaspillage sur plusieurs semaines.

Situation bc3 – Atelier avec des adolescents

Lors d'un atelier, des adolescents se moquent d'un camarade en surpoids. L'animateur intervient immédiatement pour rappeler les règles du groupe (respect, non-jugement), puis recentre l'activité sur le plaisir et les compétences, sans parler de poids : il prévient la **stigmatisation** et protège l'estime de soi de chacun.

Situation bc3 – Projet interculturel

Dans un centre d'hébergement, le diététicien conçoit un livret de recettes avec les résidents, à partir des plats de leurs pays adaptés aux produits disponibles : il favorise l'**intégration** (Berry) et l'**action communautaire** (Ottawa).

Situation bc1 – Écoute active en consultation

Un patient répond « oui, mais » à chaque conseil. Le diététicien repère son réflexe correcteur, passe à l'écoute réflective et à la balance décisionnelle ; le patient formule lui-même un premier objectif.

Situation bc3 – Un groupe en turbulence

Lors du 2e atelier d'un cycle pour des salariés, deux participants contestent les repères et se moquent des « recettes de régime ». Le diététicien accueille l'objection, la renvoie au groupe, rappelle le cadre et propose une dégustation comparée : la séance suivante, le groupe fixe ses propres règles.

Méthode 1 – Justifier un choix d'animation par un modèle, à l'oral

À l'oral de l'épreuve E5, le jury demande souvent : « Pourquoi avez-vous choisi cette technique ? » ou « Sur quel modèle vous êtes-vous appuyé ? ». Une réponse qui cite un modèle **sans le relier** au public et à l'action ne convainc pas.

Méthode pas à pas – La réponse en 4 temps

1. Le constat : ce que le diagnostic a montré sur le public (un chiffre, une citation).

2. Le modèle : son nom, son auteur, son année, et la composante qui éclaire le constat.

3. Le choix : la technique ou l'action retenue, et pourquoi elle agit sur cette composante.

4. La preuve : ce qui a été observé ou mesuré pendant ou après l'action.

À l'oral – Exemple de réponse

« Au questionnaire, les 18 parents interrogés trouvaient les légumes secs bons pour la santé, avec un score moyen de 4,2 sur 5, mais seulement 2,1 sur 5 pour l'affirmation "je sais les cuisiner". Selon la théorie du comportement planifié d'Ajzen (1991), c'est le contrôle perçu qui bloquait, pas l'attitude. J'ai donc choisi un atelier où chaque parent cuisinait lui-même un plat, plutôt qu'une présentation des bienfaits des légumineuses : c'est l'expérience de réussite, la source la plus forte du sentiment d'efficacité personnelle selon Bandura. À la fin du cycle, le score "je sais les cuisiner" est passé à 3,8 sur 5, et 11 parents sur 18 ont dit avoir refait une recette chez eux. » (Données de l'exemple fictives.)

Ce que le jury attend – Les erreurs fréquentes

- Réciter un modèle (les six étapes de Prochaska) sans dire à quoi il a servi dans le projet.
- Confondre **attitude** (ce que je pense) et **comportement** (ce que je fais), ou **norme descriptive** et **norme injonctive**.
- Annoncer une action « participative » alors que la séance était un exposé suivi de questions.
- Parler d'« éduquer » ou de « faire prendre conscience » sans dire quelle **compétence** a été travaillée.
- Oublier la **posture** : non-jugement, respect de l'autonomie, absence de stigmatisation.

Méthode 2 – Analyser une situation de groupe en quatre questions

Les sujets proposent souvent un extrait d'échange ou la description d'une séance difficile. Cette grille permet de ne rien oublier.

Question	Notions à mobiliser
1. Où en est le groupe ?	Étapes de Tuckman, rôles de Benne et Sheats, normes du groupe
2. Quelles influences jouent ?	Conformisme, leader, influence minoritaire, normes sociales, identité de groupe
3. Comment l'animateur communique-t-il ?	Attitudes de Porter, écoute active, réflexe correcteur, rapport reflets / questions, style d'animation
4. Que proposer ?	Technique d'animation adaptée, reformulation de la réplique, règle du groupe, suite de la séance

Méthode 3 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve

À vous de jouer – Vrai ou faux commentés

Pour chaque affirmation, dites si elle est vraie ou fausse et justifiez en une phrase.

1. « Une représentation sociale est une opinion personnelle. »
2. « Le noyau central d'une représentation change facilement. »
3. « Dans l'expérience de Lewin (1943), les conférences ont été plus efficaces que les discussions de groupe. »
4. « Une norme descriptive dit ce que l'on doit faire. »
5. « La dissonance cognitive conduit toujours à changer de comportement. »
6. « Un acte libre et public engage davantage qu'un acte contraint et privé. »
7. « La stigmatisation du poids motive les personnes à maigrir. »
8. « Les compétences psychosociales se développent par une information claire sur la santé. »
9. « La rechute fait partie du modèle de Prochaska et DiClemente. »
10. « Une forte intention garantit le comportement. »
11. « Il faut 21 jours pour créer une habitude. »
12. « 93 % de la communication est non verbale. »
13. « Récompenser un enfant qui goûte un légume augmente durablement son goût pour ce légume. »
14. « Un nudge peut supprimer une option pour orienter le choix. »
15. « Une échelle de Likert mélange des affirmations positives et négatives. »

Corrigé – Vrai ou faux commentés

1. Faux : c'est une connaissance **partagée** par un groupe, construite socialement (Moscovici, 1961).
2. Faux : il est stable et résistant ; ce sont les éléments périphériques qui changent d'abord (Abric).
3. Faux : environ 3 % contre 32 % ; la discussion et la décision de groupe ont été bien plus efficaces.
4. Faux : elle dit ce que **font** les autres ; c'est la norme injonctive qui dit ce qu'il faut faire.
5. Faux : la personne peut aussi changer sa croyance ou ajouter une justification, ce qui est souvent plus facile.
6. Vrai : liberté, caractère public, répétition et coût augmentent l'engagement (Kiesler ; Joule et Beauvois).
7. Faux : elle augmente le stress, l'évitement des soins et l'hyperphagie (Puhl et Heuer, 2009).
8. Faux : elles se développent par des activités **pratiques**, structurées et répétées (critères SAFE).
9. Vrai : elle est considérée comme une étape normale du processus.
10. Faux : il existe un écart intention-comportement ; les plans « si…, alors… » aident à le réduire (Gollwitzer, 1999).
11. Faux : 66 jours en valeur médiane, de 18 à 254 jours selon les personnes (Lally, 2010).
12. Faux : les chiffres de Mehrabian (1967) portent sur l'expression des sentiments dans des conditions très particulières.
13. Faux : la récompense attendue diminue la motivation intrinsèque (Lepper, Greene et Nisbett, 1973 ; Wardle, 2003).
14. Faux : un nudge laisse toutes les options accessibles ; supprimer une option est une restriction.
15. Vrai : cela limite les réponses automatiques ; les affirmations négatives sont inversées avant le calcul.

Mon score	Ce que je fais
14 ou 15 sur 15	Je suis prêt pour les sujets d'entraînement.
10 à 13 sur 15	Je relis les sections des affirmations manquées.
Moins de 10 sur 15	Je reprends les encadrés « À retenir » du chapitre et je refais les points d'étape.

3.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Concepts

- **Psychologie** (individu), **sociologie** (groupes, faits sociaux), **anthropologie** (cultures) ; la **psychologie sociale** étudie l'influence des autres sur l'individu.
- Repères : Lévi-Strauss (1964), Bourdieu (1979), **Fischler** (1990 : paradoxe de l'omnivore, incorporation, gastro-anomie), **Poulain** (2002 : espace social alimentaire).
- **Identité** individuelle et sociale (Tajfel et Turner, 1979) ; **socialisation** primaire (famille) et secondaire (école, pairs, travail, médias).
- **Représentations sociales** (Moscovici, 1961 ; noyau central et périphérie, Abric) ; **normes** descriptives et injonctives ; **valeurs** ; **attitudes**.
- **Culture**, **interculturalité** (décentration), **acculturation** spontanée / planifiée (Bastide) ; stratégies de **Berry** (1997) : intégration, assimilation, séparation, marginalisation.

À retenir – Groupe, CPS, changement

- **Lewin (1943)** : la discussion de groupe et la décision collective changent davantage les pratiques (≈ 32 %) que la conférence (≈ 3 %).
- **Conformisme** (Asch), **dissonance cognitive** (Festinger, 1957), **engagement** (Kiesler ; Joule et Beauvois), **stigmatisation** (Goffman, 1963).
- **CPS** (Santé publique France, 2022) : 3 catégories (cognitives, émotionnelles, sociales) × 3 CPS générales.
- **Image corporelle**, insatisfaction corporelle, **émotions** (Ekman), **estime de soi** (Rosenberg), **efficacité personnelle** (Bandura, 1977).
- **Modèles du changement** : HBM ; Prochaska et DiClemente (1983) : précontemplation, contemplation, préparation, action, maintien, rechute ; Ajzen (1991) : attitude, normes subjectives, contrôle perçu → intention → comportement.
- **Néophobie** : maximale de 2 à 6 ans ; 8 à 15 expositions sans pression ; éviter la récompense alimentaire.

À retenir – Compléments : communication, motivation, animation, mesure

- **Palo Alto** : on ne peut pas ne pas communiquer ; contenu et relation. **Mehrabian** : pas de « 93 % de non-verbal » en général.
- **Écoute active** (Rogers) : empathie, acceptation, congruence ; questions ouvertes, reformulation, reflets, silences, synthèse ; **Porter** : 6 attitudes, privilégier la compréhension.
- **Entretien motivationnel** (Miller et Rollnick) : partenariat, acceptation, compassion, évocation ; ambivalence ; réflexe correcteur ; OuVER ; **balance décisionnelle**.
- **Groupe** : Tuckman (formation, turbulence, normalisation, production, dissolution) ; rôles (Benne et Sheats) ; styles (Lewin, Lippitt et White : démocratique > autoritaire > laisser-faire).
- **Motivation** : autodétermination (autonomie, compétence, affiliation) ; éviter les récompenses alimentaires ; **biais** (présent, cadrage, halo, défaut, ancrage, optimisme, preuve sociale).
- **Mesure** : Likert (inverser les items négatifs : 6 − réponse) ; évocation hiérarchisée et analyse prototypique (fréquence × rang moyen ; noyau central probable).

3.8 Entraînement

3.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – La psychologie sociale étudie :

a) l'influence des autres sur les pensées et les comportements de l'individu **b)** uniquement les maladies mentales **c)** les interactions entre l'individu et le groupe **d)** la composition des aliments

QCM 2 – La socialisation primaire se fait principalement :

a) au travail **b)** dans la famille **c)** par les réseaux sociaux à l'âge adulte **d)** pendant l'enfance

QCM 3 – Le « paradoxe de l'omnivore » a été décrit par :

a) Claude Fischler **b)** Kurt Lewin **c)** Albert Bandura **d)** John Berry

QCM 4 – Une représentation sociale :

a) est une connaissance socialement élaborée et partagée **b)** comporte un noyau central stable **c)** est toujours fausse **d)** oriente les comportements

QCM 5 – Dans le modèle de Berry, conserver ses pratiques d'origine tout en adoptant celles du pays d'accueil correspond à :

a) l'assimilation **b)** l'intégration **c)** la séparation **d)** la marginalisation

QCM 6 – Dans l'expérience de Lewin (1943), le changement le plus important a été obtenu par :

a) une conférence d'expert **b)** une discussion de groupe suivie d'une décision collective **c)** une affiche **d)** une sanction

QCM 7 – La dissonance cognitive :

a) est un inconfort lié à des cognitions contradictoires **b)** peut conduire à rationaliser plutôt qu'à changer **c)** est renforcée par des messages culpabilisants **d)** a été décrite par Festinger

QCM 8 – Les compétences psychosociales selon Santé publique France (2022) sont classées en :

a) cognitives, émotionnelles, sociales **b)** physiques, mentales, sociales **c)** primaires, secondaires, tertiaires **d)** individuelles et collectives uniquement

QCM 9 – Réguler ses émotions est une CPS :

a) cognitive **b)** émotionnelle **c)** sociale **d)** physique

QCM 10 – Dans le modèle de Prochaska et DiClemente, une personne qui a changé de comportement depuis 3 mois est au stade :

a) de contemplation **b)** de préparation **c)** d'action **d)** de maintien

QCM 11 – Selon Ajzen, l'intention dépend :

a) de l'attitude **b)** des normes subjectives **c)** du contrôle comportemental perçu **d)** de l'IMC

QCM 12 – La source la plus puissante du sentiment d'efficacité personnelle est :

a) la persuasion verbale **b)** l'expérience de réussite personnelle **c)** la peur **d)** la sanction

QCM 13 – Face à la néophobie d'un enfant de 4 ans, il est recommandé :

a) de forcer à finir l'assiette **b)** de proposer l'aliment à plusieurs reprises sans pression **c)** de promettre un dessert en récompense **d)** de manger soi-même l'aliment devant l'enfant

QCM 14 – La stigmatisation du poids :

a) motive les personnes à perdre du poids **b)** augmente le stress et l'évitement des soins **c)** est un facteur de risque de comportements alimentaires désordonnés **d)** a été théorisée sous le nom de stigmate par Goffman

QCM 15 – Une norme descriptive :

a) décrit ce que font la plupart des gens **b)** dit ce qu'il faut faire **c)** peut normaliser un comportement à éviter si elle est mal utilisée **d)** est toujours inefficace

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, c. 2. **b, d**. 3. **a** (*L'Homnivore*, 1990). 4. **a, b, d** : une représentation n'est pas « fausse », elle a une cohérence pour le groupe. 5. **b**. 6. **b** (≈ 32 % contre ≈ 3 %). 7. **a, b, c, d**. 8. **a**. 9. **b**. 10. **c** (moins de 6 mois). 11. **a, b, c**. 12. **b** (Bandura). 13. **b, d** : la pression et la récompense sont contre-productives. 14. **b, c, d** : la stigmatisation ne motive pas, elle nuit. 15. **a, c**.

QCM 16 – Parmi les attitudes de Porter, celle qui favorise le plus l'expression est :

a) l'évaluation **b)** la solution **c)** la compréhension **d)** l'enquête

QCM 17 – L'esprit de l'entretien motivationnel comprend :

a) le partenariat **b)** l'évocation **c)** la confrontation **d)** l'acceptation

QCM 18 – Selon Tuckman, la phase où apparaissent les désaccords est :

a) la formation **b)** la turbulence **c)** la normalisation **d)** la production

QCM 19 – Dans la théorie de l'autodétermination, les trois besoins fondamentaux sont :

a) autonomie **b)** compétence **c)** affiliation **d)** récompense

QCM 20 – Dans une échelle de Likert de 1 à 5, la réponse 4 à un item négatif devient après inversion :

a) 1 **b)** 2 **c)** 4 **d)** 5

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM complémentaires

16. c. 17. **a, b, d**. 18. **b**. 19. **a, b, c**. 20. **b** (6 − 4 = 2).

3.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les stratégies d'acculturation

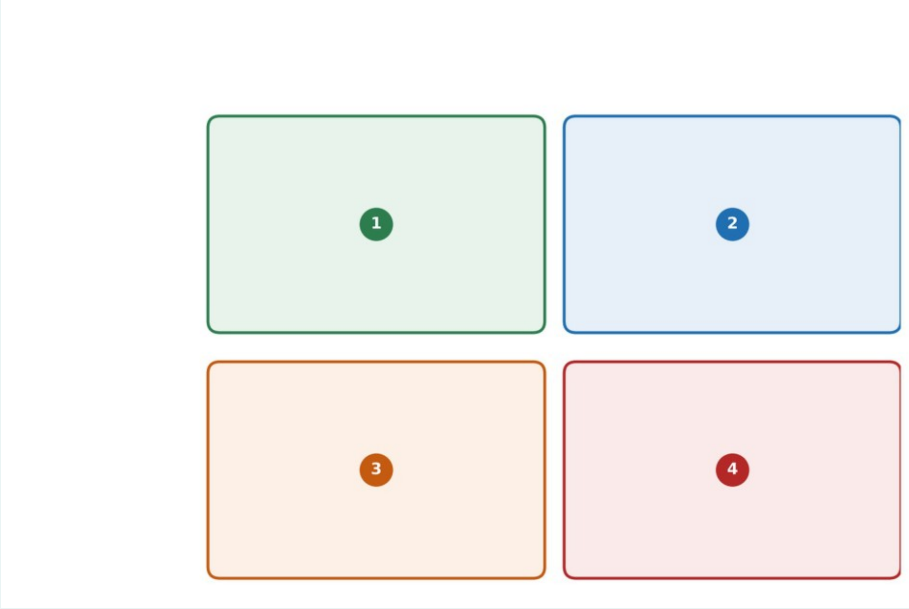


Figure 3.10 – Schéma à légender

Nommez le modèle, l'auteur et la date ; légendez les cases 1 à 4 et donnez un exemple alimentaire pour

chacune.

Corrigé

Stratégies d'acculturation de **John Berry (1997)**. 1. **Intégration** : une famille marocaine cuisine le tajine et adopte la ratatouille. 2. **Assimilation** : abandon des plats d'origine au profit de plats industriels du pays d'accueil. 3. **Séparation** : maintien exclusif des plats d'origine, achats uniquement dans des épiceries communautaires. 4. **Marginalisation** : perte des repères culinaires d'origine sans adoption de nouveaux, alimentation désorganisée (repas sautés, produits transformés).

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : les étapes du changement

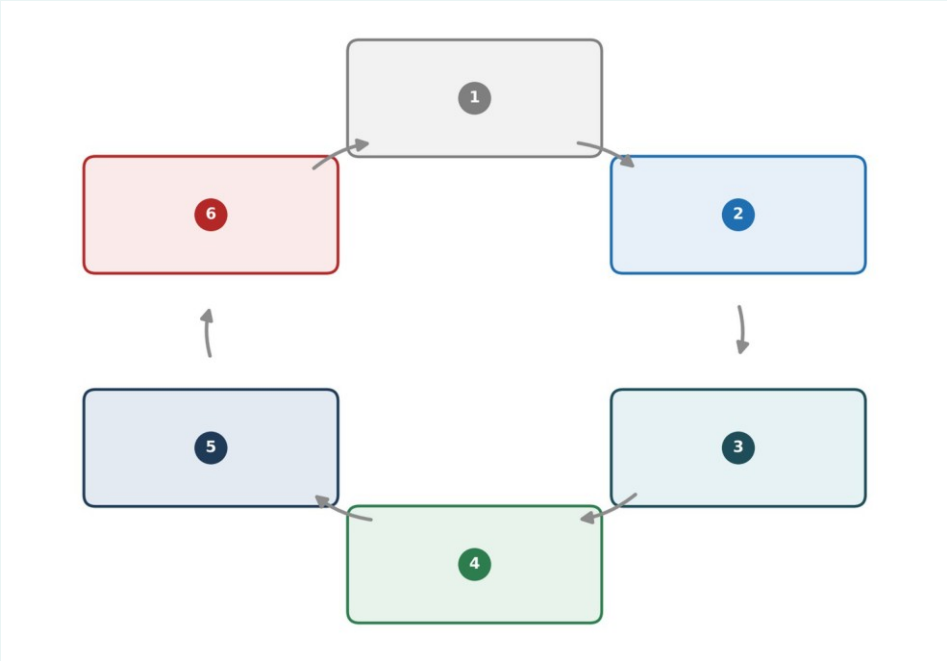


Figure 3.11 – Schéma à légender

Légendez les étapes 1 à 6 et proposez pour chacune une attitude de l'éducateur.

Corrigé

1. Précontemplation : informer sans braquer, susciter la curiosité. 2. **Contemplation** : explorer l'ambivalence (avantages / inconvénients). 3. **Préparation** : aider à fixer un objectif concret. 4. **Action** : soutenir, valoriser, résoudre les obstacles. 5. **Maintien** : prévenir la rechute, varier. 6. **Rechute** : dédramatiser, analyser, relancer le cycle.

À vous de jouer – Exercice 3 – Classer des CPS

Classez dans les trois catégories : a) dire non à un soda proposé par un ami ; b) repérer qu'on mange par ennui ; c) analyser une publicité ; d) gérer le stress d'un examen sans grignoter ; e) cuisiner en équipe ; f) choisir un menu équilibré dans un budget.

Corrigé

Cognitives : c) pensée critique ; f) prise de décision. **Émotionnelles** : b) conscience de ses émotions ; d) gestion du stress. **Sociales** : a) communication constructive (affirmation de soi) ; e) relations constructives

(coopération).

À vous de jouer – Exercice 4 – Identifier des représentations

Voici des propos recueillis lors d'un photolangage : « Le bio, c'est pour les riches » ; « Un bon repas, c'est avec de la viande » ; « Les surgelés, c'est mauvais » ; « Le pain, ça fait grossir ». Pour chacune, proposez une façon de la faire évoluer sans la disqualifier.

Corrigé

- « Le bio, c'est pour les riches » : reconnaître que certains produits bio sont plus chers ; montrer que des produits bio de saison ou en vrac (pommes, lentilles) sont abordables ; calculer le coût par portion.
- « Un bon repas, c'est avec de la viande » : valoriser la convivialité et la générosité du repas (noyau), proposer un plat sans viande copieux et apprécié (périphérie), puis parler de complémentarité des protéines.
- « Les surgelés, c'est mauvais » : distinguer légumes surgelés nature (intéressants nutritionnellement et économiquement) et plats préparés ; faire goûter.
- « Le pain fait grossir » : rappeler que le pain, surtout complet, est un féculent recommandé ; ce sont surtout les quantités et ce qu'on met dessus qui comptent.

À vous de jouer – Exercice 5 – Appliquer la théorie d'Ajzen

Mme K. pense que les légumes secs sont bons pour la santé (attitude positive), mais son mari dit qu'« un repas sans viande n'est pas un repas » et elle ne sait pas les cuisiner. Analysez avec le modèle d'Ajzen et proposez une action pour chaque composante.

Corrigé

Attitude : favorable → la renforcer (goût, économie). **Normes subjectives** : défavorables (le mari) → inviter le conjoint à la dégustation, proposer des plats mixtes (légumineuses + un peu de viande). **Contrôle perçu** : faible (ne sait pas cuisiner) → atelier pratique, recette simple, conserves de légumineuses pour gagner du temps. L'intention, aujourd'hui faible malgré l'attitude positive, augmentera si les normes et le contrôle perçu deviennent favorables.

À vous de jouer – Exercice 6 – Repérer les erreurs d'animation

Dans un atelier pour enfants, l'animatrice dit : « Celui qui ne goûte pas les épinards n'aura pas de gâteau », puis « Regardez Lucas, il est trop gros, il doit faire attention ». Identifiez les erreurs et proposez une autre formulation.

Corrigé

Erreur 1 : **récompense alimentaire** et pression, qui dévalorisent les épinards et survalorisent le gâteau. Reformulation : « Qui veut découvrir la couleur, l'odeur et le goût des épinards ? On a le droit de ne pas aimer, on peut juste toucher ou sentir. » Erreur 2 : **stigmatisation** publique d'un enfant, atteinte à l'estime de soi et au respect de la vie privée. Il ne faut jamais commenter le corps d'un participant ; la règle de respect s'applique à tous.

À vous de jouer – Exercice 7 – Adapter une action au public

Une même action « découvrir les légumineuses » doit être proposée à : a) des enfants de 5 ans ; b) des adolescents de 15 ans ; c) des résidents d'EHPAD. Proposez une adaptation pour chacun.

Corrigé

a) Jeu sensoriel (toucher, trier des lentilles de couleurs), fabrication d'un houmous coloré, exposition répétée, parents invités. b) Défi « burger végétal » en équipes, vidéo réalisée par les élèves, arguments planète et sport, respect de leurs choix. c) Atelier réminiscence (« les lentilles de mon enfance »), velouté de lentilles à texture adaptée, repas partagé, rythme lent.

À vous de jouer – Exercice 8 – Normes descriptives

Un collège veut afficher : « 65 % des élèves ne prennent pas de petit-déjeuner ! ». Est-ce une bonne idée ? Proposez une alternative.

Corrigé

Non : ce message présente le comportement à éviter comme **majoritaire** et risque de le normaliser (effet boomerang). Si 35 % des élèves prennent un petit-déjeuner, on peut valoriser une norme favorable vraie sur un autre aspect, par exemple « 8 élèves sur 10 boivent de l'eau à la récréation », ou une norme dynamique : « de plus en plus d'élèves prennent un petit-déjeuner » (si c'est vrai), accompagnée d'actions concrètes (petit-déjeuner au collège).

À vous de jouer – Exercice 9 – Analyser une situation de dissonance

Un salarié dit : « Je sais que je mange trop de sucre, mais avec mon travail, je n'ai pas le choix, et puis il faut bien se faire plaisir. » Identifiez la dissonance et la stratégie de réduction utilisée. Comment réagir ?

Corrigé

Dissonance entre « je mange trop de sucre » et « le sucre en excès est mauvais pour la santé ». Stratégie : **rationalisation** (justification par le travail et le plaisir) plutôt que changement. Réaction : ne pas culpabiliser ; reconnaître la contrainte et le besoin de plaisir ; explorer avec lui des solutions compatibles (collation plaisir moins sucrée, aménagement de la pause) ; renforcer son sentiment d'efficacité par un petit objectif.

À vous de jouer – Exercice 10 – Recueillir des représentations

Rédigez la consigne et le déroulé d'un photolangage de 30 minutes pour un groupe de 8 parents sur le thème « bien manger pour ma famille ».

Corrigé

Préparation : 40 photos variées (repas, aliments, scènes de repas, marché, cuisine, fast-food, fête). **Consigne** : « Choisissez une photo qui représente pour vous "bien manger pour ma famille", et une photo qui représente ce qui est difficile. » **Déroulé** : 5 min de choix en silence ; 20 min de tour de table (chacun explique, l'animateur reformule sans juger, note les mots-clés) ; 5 min de synthèse (regroupement des idées : plaisir, santé, prix, temps, enfants). **Règles** : bienveillance, droit de ne pas parler, confidentialité. **Exploitation** : les thèmes deviennent des objectifs d'atelier.

3.8.3 Questions de réflexion

À vous de jouer – Question 1

En quoi votre propre culture alimentaire peut-elle influencer votre pratique professionnelle ?

Corrigé

Chacun juge l'alimentation des autres à travers ses propres normes (horaires, plats, valeurs) : risque d'**ethnocentrisme** (considérer sa culture comme la référence). La **décentration** consiste à prendre conscience de ses propres valeurs et préjugés (par exemple, penser qu'un repas « normal » comporte entrée, plat, dessert) pour accueillir d'autres pratiques sans les juger, en ne retenant que les critères nutritionnels réellement importants. Le guide du BTS invite explicitement l'apprenant à « s'interroger sur son système de valeurs et à le confronter à celui des autres ».

À vous de jouer – Question 2

Pourquoi une conférence sur l'équilibre alimentaire change-t-elle rarement les comportements ?

Corrigé

Parce que l'information agit surtout sur les **connaissances** et l'**attitude**, peu sur les **normes** du groupe, le **contrôle perçu** (compétences, moyens) et les **habitudes** ; elle ne crée pas d'**engagement**. Lewin a montré que la discussion de groupe et la décision collective étaient bien plus efficaces ; Bandura, que l'expérience de réussite développe l'efficacité personnelle. Une action participative et pratique (atelier culinaire) est donc préférable.

À vous de jouer – Question 3

Les techniques d'engagement sont-elles une forme de manipulation ?

Corrigé

Elles peuvent l'être si elles sont utilisées à l'insu de la personne et contre son intérêt (marketing). En éducation pour la santé, leur usage est **éthique** si l'objectif est l'intérêt de la personne, si elle reste **libre** (sentiment de liberté explicite), si le professionnel est **transparent** sur ses intentions et si l'objectif est choisi par la personne elle-même. C'est la différence entre manipulation et accompagnement du pouvoir d'agir.

3.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – Un club de football de jeunes

L'éducateur d'un club de football (garçons et filles de 13 à 16 ans) observe : boissons énergisantes avant les matchs, une joueuse qui « saute des repas pour être plus légère », moqueries sur le poids d'un gardien, défis alimentaires repris des réseaux sociaux. Il vous sollicite.

1. Identifiez les phénomènes psychosociaux en jeu.
2. Quelles CPS faudrait-il développer chez ces jeunes ?
3. Proposez une action en 3 séances.
4. Que faites-vous concernant la joueuse qui saute des repas ?
5. Comment impliquer les parents et l'éducateur ?

Corrigé

1. Influence des pairs et **conformisme** (boissons énergisantes, défis), **socialisation secondaire** par les réseaux sociaux, **insatisfaction corporelle** et risque de restriction (joueuse), **stigmatisation** du poids (gardien), construction de l'**identité** adolescente.

2. Pensée critique (analyser publicités et défis), **affirmation de soi** et communication constructive (refuser), **conscience et régulation des émotions**, **estime de soi**, **relations constructives** (respect dans l'équipe).

3. Séance 1 « Mon carburant » : besoins du sportif, collation avant l'effort (atelier pratique), hydratation. Séance 2 « Décrypter » : analyse d'une publicité et d'un défi viral, débat, élaboration de règles de l'équipe. Séance 3 « Respect » : jeu de rôle sur les moqueries, charte d'équipe signée par tous (engagement), valorisation des forces de chacun.

4. Ne pas en parler devant le groupe ; signaler la situation à l'éducateur et aux parents avec tact, en conseillant une consultation (médecin, diététicien, médecin du sport), car il peut s'agir d'un signe de **trouble du comportement alimentaire** ou de déficit énergétique ; je ne pose pas de diagnostic.

5. Réunion d'information des parents (collations, boissons, repérage des signes d'alerte), outils pour l'éducateur (charte, consignes sur les commentaires corporels), éventuellement un temps convivial avec dégustation de collations.

3.8.5 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Un participant refuse de goûter : « Chez nous, on ne mange pas ça. »

Corrigé

Je respecte son refus sans insister, je lui demande ce qu'on mange chez lui et s'il veut partager une recette ; je lui propose un rôle (préparer, sentir, décrire) ; la porte reste ouverte pour une prochaine fois.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Qu'est-ce que la socialisation secondaire ? Exemple dans votre projet. »

Corrigé

La socialisation qui se poursuit après l'enfance par l'école, les pairs, le travail, les médias. Dans mon projet, les enfants réclamaient des produits vus à la cantine et chez les copains : c'est la socialisation secondaire qui influence la famille.

Mise en situation – MSE 3

Une mère dit avoir honte de « mal nourrir » ses enfants.

Corrigé

J'écoute, je reformule son émotion (« vous vous inquiétez pour vos enfants »), je valorise ce qu'elle fait déjà de favorable, je propose des solutions concrètes et accessibles ; je ne renforce pas la culpabilité.

Mise en situation – MSE 4

Comment développer le sentiment d'efficacité personnelle en atelier ?

Corrigé

Faire réaliser la recette par les participants (expérience de réussite), montrer des pairs qui réussissent (témoignages), encourager, créer un climat détendu, choisir des recettes simples au début.

Mise en situation – MSE 5

Un adolescent se moque du poids d'un camarade pendant l'atelier.

Corrigé

J'interviens immédiatement et calmement pour rappeler la règle de respect, je recentre l'activité, je reparle à l'adolescent en aparté, et je veille à ce que le camarade ne soit pas exposé.

Mise en situation – MSE 6

Quelle est la différence entre acculturation spontanée et planifiée ?

Corrigé

Spontanée : changement non dirigé, par le contact quotidien (adopter les produits du supermarché). Planifiée : changement organisé volontairement par une institution (programme d'éducation alimentaire, cantine).

Mise en situation – MSE 7

Votre tutrice veut afficher « 70 % des enfants du quartier sont en mauvaise santé à cause de leur alimentation ».

Corrigé

Ce message est stigmatisant et probablement inexact ; je propose un message positif fondé sur une norme favorable ou un conseil concret (« les goûters maison, c'est bon et pas cher »), et je vérifie la donnée.

Mise en situation – MSE 8

Pourquoi ne pas utiliser le dessert comme récompense ?

Corrigé

Parce que cela valorise le dessert et dévalorise l'aliment à manger « pour avoir droit » au dessert ; à long terme, l'enfant préfère encore plus l'aliment récompense.

Mise en situation – MSE 9

Qu'est-ce que l'écoute active ?

Corrigé

Écouter avec attention, sans juger ni interrompre, en montrant qu'on a compris (reformulation, questions ouvertes, attention au non verbal) ; elle fait partie des CPS sociales et des indicateurs de C3.5.

Mise en situation – MSE 10

Le jury vous demande quel modèle du changement vous avez utilisé.

Corrigé

Par exemple Ajzen : j'ai agi sur l'attitude (dégustation), les normes (décision en groupe, conjoints invités) et surtout le contrôle perçu (cuisiner soi-même, recettes rapides et peu coûteuses).

Mise en situation – MSE 11

Une résidente d'EHPAD ne mange plus depuis l'entrée en établissement.

Corrigé

Je pense aux dimensions psychosociales (perte de repères, tristesse, isolement, perte de l'identité de « cuisinière ») ; je propose avec l'équipe de recueillir ses goûts, de l'associer à une activité culinaire, de favoriser la convivialité, et je signale la perte d'appétit (risque de dénutrition, dépistage).

Mise en situation – MSE 12

Un collègue dit : « Les gens savent ce qu'il faut manger, ils ne font pas d'efforts. »

Corrigé

Savoir ne suffit pas : le comportement dépend aussi des normes, des émotions, des habitudes, du contrôle perçu et des déterminants sociaux. Je propose de s'appuyer sur des approches participatives et sur l'environnement plutôt que sur la volonté individuelle.

3.8.6 Exercices complémentaires

À vous de jouer – Exercice 11 – Calculer des scores de Likert

Échelle de 4 items (1 à 5) sur l'attitude envers l'eau du robinet : I1 « L'eau du robinet est bonne pour la santé » (+) ; I2 « L'eau du robinet a mauvais goût » (−) ; I3 « Je fais confiance à l'eau de ma commune » (+) ; I4 « L'eau en bouteille est plus sûre » (−). Réponses de 3 personnes : P1 : 4, 2, 4, 2 ; P2 : 2, 5, 1, 5 ; P3 : 3, 3, 4, 3. Calculez les scores sur 100 et la moyenne.

Corrigé

Inversion des items négatifs (6 − réponse). P1 : 4 + (6 − 2) + 4 + (6 − 2) = 4 + 4 + 4 + 4 = **16** ; sur 100 : (16 − 4) / (20 − 4) × 100 = 12 / 16 × 100 = **75**. P2 : 2 + 1 + 1 + 1 = **5** ; (5 − 4) / 16 × 100 = **6,25**. P3 : 3 + 3 + 4 + 3 = **13** ; (13 − 4) / 16 × 100 = **56,25**. Moyenne : (75 + 6,25 + 56,25) / 3 = 137,5 / 3 = **45,8 / 100**. P2 est très défavorable : l'écouter sur ses raisons (goût de chlore, méfiance) avant d'informer (qualité contrôlée, carafe au réfrigérateur pour atténuer le goût).

À vous de jouer – Exercice 12 – Reformuler

Proposez une reformulation simple et une reformulation reflet pour : a) « Je n'ai pas le temps de cuisiner le soir, je rentre à 19 h » ; b) « Mon médecin m'a dit de perdre du poids, mais j'en ai marre des régimes » ; c) « Les enfants préfèrent la cantine à ce que je fais. »

Corrigé

a) Simple : « Vous rentrez tard et le temps manque pour cuisiner. » Reflet : « Ça a l'air épuisant, ces soirées. » b) Simple : « On vous a conseillé de perdre du poids, et les régimes ne vous conviennent plus. » Reflet : « Vous semblez découragé(e) par les régimes. » c) Simple : « Vos enfants apprécient les repas de la cantine. » Reflet : « Ça vous peine un peu qu'ils préfèrent la cantine. »

À vous de jouer – Exercice 13 – Balance décisionnelle

Une étudiante hésite à remplacer son soda quotidien par de l'eau aromatisée maison. Pour : économie (4), moins de sucre (3), meilleure peau (1). Contre : perte du plaisir (4), habitude avec les amis (3), préparer la bouteille (2). Calculez la balance, interprétez et proposez deux actions sur les « contre ».

Corrigé

Pour : 4 + 3 + 1 = **8** ; contre : 4 + 3 + 2 = **9** ; écart : 8 − 9 = **− 1** : légère dominante du statu quo, ambivalence. Actions : réduire la perte de plaisir (eau pétillante citron-menthe, soda gardé le week-end) : 4 → 2 ; préparer 3 bouteilles le dimanche : 2 → 1. Nouveau total « contre » : 2 + 3 + 1 = **6** ; écart : 8 − 6 = **+ 2**. C'est elle qui choisit ; on valorise son choix, même partiel.

À vous de jouer – Exercice 14 – Gérer des participants

Pour chaque situation, proposez une réponse d'animateur : a) M. P. coupe la parole à chaque intervention ; b) Mme S. ne dit rien depuis trois séances mais cuisine avec soin ; c) un participant affirme : « Les diététiciens disent n'importe quoi, ça change tout le temps. »

Corrigé

a) « Merci, M. P., votre expérience est précieuse ; j'aimerais maintenant entendre d'autres personnes » ; tour de parole ; lui confier un rôle (chronométrer, servir). b) Respecter son rythme ; valoriser son plat devant le groupe avec son accord ; lui proposer une question en binôme ; support non verbal (gommette). c) Accueillir : « Vous avez l'impression que les conseils changent souvent. » Puis expliquer que les repères évoluent avec les connaissances (exemple des repères de 2019) et que l'essentiel reste stable (fruits, légumes, légumes secs) ; renvoyer au groupe.

À vous de jouer – Exercice 15 – Repérer des biais dans une publicité

Une publicité pour des biscuits affiche « Source de céréales complètes – 30 % de sucres en moins » avec un sportif souriant. Identifiez les biais exploités et rédigez deux questions pour un atelier de littératie critique.

Corrigé

Effet de halo (céréales complètes, sportif → produit perçu comme sain) ; **cadrage** (« 30 % de sucres en moins » par rapport à un produit très sucré, sans valeur absolue) ; **preuve sociale** et identification. Questions : « 30

% de moins que quoi ? Combien de sucres pour 100 g ? » ; « Comparez le Nutri-Score avec celui d'une tartine de pain et de fromage. »

À vous de jouer – Exercice 16 – Motivation et récompenses

Un animateur de centre de loisirs promet un bonbon aux enfants qui goûtent la soupe. Analysez avec la théorie de l'autodétermination et proposez une alternative.

Corrigé

La récompense est une **motivation extrinsèque** : elle peut faire goûter une fois, mais elle associe la soupe à une corvée et le bonbon au plaisir, et affaiblit l'envie de goûter pour elle-même. Alternative : satisfaire l'**autonomie** (choisir entre deux soupes, se servir), la **compétence** (préparer la soupe, reconnaître les légumes) et l'**affiliation** (l'animateur goûte avec les enfants, on décrit ensemble les saveurs), avec exposition répétée et sans pression.

3.9 Glossaire

Terme	Définition
Acculturation	Changements résultant du contact continu entre groupes de cultures différentes (spontanée ou planifiée)
Attitude	Disposition favorable ou défavorable envers un objet (cognitive, affective, conative)
Compétences psychosociales	Capacités cognitives, émotionnelles et sociales qui augmentent le pouvoir d'agir et le bien-être
Conformisme	Alignement de son jugement ou comportement sur celui du groupe
Culture	Manières de penser, sentir et agir apprises et partagées, transmises entre générations
Dissonance cognitive	Inconfort lié à des cognitions contradictoires
Engagement	Lien entre une personne et ses actes, renforcé par la liberté, la publicité, la répétition
Estime de soi	Valeur qu'une personne s'attribue
Gastro-anomie	Perte des règles collectives de l'alimentation laissant le mangeur seul face à des injonctions contradictoires (Fischler)
Identité sociale	Partie de l'image de soi issue de l'appartenance à des groupes
Image corporelle	Représentation mentale de son corps (perception, pensées, émotions, comportements)
Interculturalité	Relations et échanges entre personnes de cultures différentes, fondés sur la reconnaissance mutuelle
Néophobie alimentaire	Réticence à goûter des aliments nouveaux, maximale entre 2 et 6 ans
Norme sociale	Règle de conduite attendue dans un groupe (descriptive ou injonctive)
Représentation sociale	Connaissance socialement élaborée et partagée, organisée autour d'un noyau central
Sentiment d'efficacité personnelle	Croyance en sa capacité à réaliser une action (Bandura)

Terme	Définition
Socialisation	Intériorisation des normes, valeurs et pratiques d'une société (primaire, secondaire)
Stigmatisation	Processus qui disqualifie une personne en la réduisant à un attribut (Goffman)
Syncrétisme culinaire	Combinaison d'éléments de cultures culinaires différentes
Valeur	Idéal collectif qui oriente les jugements
Ambivalence	Fait de vouloir et de ne pas vouloir changer en même temps
Balance décisionnelle	Outil listant et pondérant avantages et inconvénients d'un changement
Biais cognitif	Déviation systématique du jugement, liée aux raccourcis de pensée
Écoute active	Écoute centrée sur la personne : empathie, acceptation, congruence, reformulation
Entretien motivationnel	Style de conversation collaboratif renforçant la motivation propre au changement
Évocation hiérarchisée	Recueil de mots associés à un objet, dans leur ordre d'apparition
Habitus	Dispositions durables acquises par la socialisation, qui orientent les goûts (Bourdieu)
Motivation intrinsèque	Agir pour l'intérêt ou le plaisir de l'activité elle-même
Pair-éducation	Action éducative menée par des membres du groupe cible formés
Reformulation	Redire avec d'autres mots ce que la personne a exprimé
Style d'animation	Manière de conduire un groupe : autoritaire, démocratique, laisser-faire

3.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Sociologie et anthropologie de l'alimentation	[1] Fischler ; [2] Poulain ; [3] Lévi-Strauss ; [4] Bourdieu
Identité, représentations, influence	[5] Tajfel et Turner ; [6] Moscovici ; [7] Abric ; [8] Lewin ; [9] Festinger ; [10] Joule et Beauvois
Culture et acculturation	[11] Berry ; [12] Cohen-Emerique
CPS	[13] Santé publique France 2022 ; [14] OMS 1993
Image corporelle, émotions, stigmatisation	[15] Goffman ; [16] Rubino et coll.
Changement de comportement	[17] Prochaska et DiClemente ; [18] Ajzen ; [19] Bandura ; [20] Miller et Rollnick ; [21] Michie et coll.

3.12 Bibliographie numérotée

1. Fischler C. *L'Homnivore*. Paris, Odile Jacob, 1990.

2. Poulain J.-P. *Sociologies de l'alimentation*. Paris, PUF, 2002 (rééd. 2017).

3. Lévi-Strauss C. *Mythologiques I. Le cru et le cuit*. Paris, Plon, 1964.

4. Bourdieu P. *La Distinction. Critique sociale du jugement*. Paris, Minuit, 1979.

5. Tajfel H., Turner J. « An integrative theory of intergroup conflict », in Austin W., Worchel S. (dir.), *The Social Psychology of Intergroup Relations*, 1979.

6. Moscovici S. *La psychanalyse, son image et son public*. Paris, PUF, 1961.

7. Abric J.-C. (dir.). *Pratiques sociales et représentations*. Paris, PUF, 1994.

8. Lewin K. « Forces behind food habits and methods of change ». *Bulletin of the National Research Council*, 1943, n° 108, p. 35-65.

9. Festinger L. *A Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford University Press, 1957.

10. Joule R.-V., Beauvois J.-L. *Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens*. Grenoble, PUG, 1987 (rééd.).

11. Berry J. W. « Immigration, acculturation, and adaptation ». *Applied Psychology*, 1997, 46 (1), p. 5-34.

12. Cohen-Emerique M. *Pour une approche interculturelle en travail social*. Rennes, Presses de l'EHESP, 2011.

13. Santé publique France. *Les compétences psychosociales : un référentiel pour un déploiement auprès des enfants et des jeunes*. 2022.

14. OMS. *Life skills education for children and adolescents in schools*. Genève, 1993.

15. Goffman E. *Stigmate*. Paris, Minuit, 1975 (éd. originale 1963).

16. Rubino F. et coll. « Joint international consensus statement for ending stigma of obesity ». *Nature Medicine*, 2020, 26, p. 485-497.

17. Prochaska J. O., DiClemente C. C. « Stages and processes of self-change of smoking ». *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 1983, 51 (3), p. 390-395.

18. Ajzen I. « The theory of planned behavior ». *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 1991, 50 (2), p. 179-211.

19. Bandura A. « Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change ». *Psychological Review*, 1977, 84 (2), p. 191-215.

20. Miller W. R., Rollnick S. *L'entretien motivationnel*. 2e éd. française, Paris, InterÉditions, 2013.

21. Michie S., van Stralen M. M., West R. « The behaviour change wheel ». *Implementation Science*, 2011, 6:42.

22. Watzlawick P., Beavin J. H., Jackson D. D. *Une logique de la communication*. Paris, Seuil, 1972 (éd. originale 1967).

23. Rogers C. R. *Le développement de la personne*. Paris, Dunod, 1968 (éd. originale 1961).

24. Porter E. H. *An Introduction to Therapeutic Counseling*. Boston, Houghton Mifflin, 1950.

25. Miller W. R., Rollnick S. *L'entretien motivationnel : aider la personne à engager le changement*. Paris, InterÉditions, 2e éd. française 2013.

26. Tuckman B. W. « Developmental sequence in small groups ». *Psychological Bulletin*, 1965, 63 (6), p. 384-399.

27. Lewin K., Lippitt R., White R. K. « Patterns of aggressive behavior in experimentally created social climates ». *Journal of Social Psychology*, 1939, 10, p. 271-299.

28. Deci E. L., Ryan R. M. *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. New York, Plenum, 1985.

29. Kahneman D. *Système 1 / Système 2 : les deux vitesses de la pensée*. Paris, Flammarion, 2012.

30. Vergès P. « L'évocation de l'argent : une méthode pour la définition du noyau central d'une représentation ». *Bulletin de psychologie*, 1992, 45 (405), p. 203-209.

31. Tajfel H., Turner J. C. « An integrative theory of intergroup conflict ». In Austin W. G., Worchel S. (dir.), *The Social Psychology of Intergroup Relations*, 1979.

32. Bourdieu P. *La Distinction. Critique sociale du jugement*. Paris, Minuit, 1979.

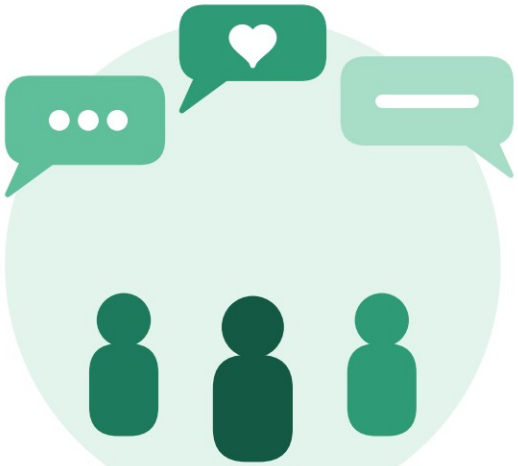
Cours du CNED (contrôle de conformité, section 3.2.2)

33. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE



CHAPITRE

03

Éléments de psychologie sociale

Psychologie | Sociologie | Anthropologie de l'alimentation

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

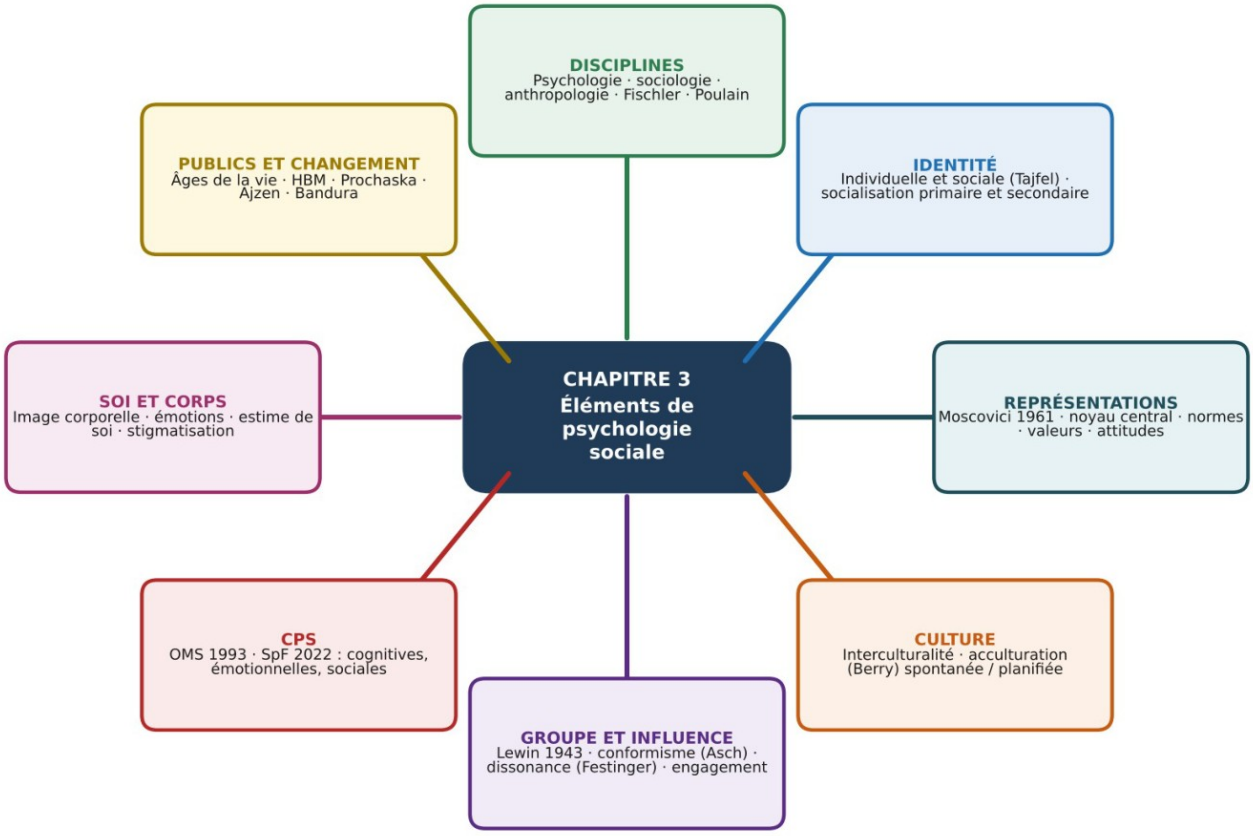
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 3 102
1. Les définitions à savoir 102
2. Les modèles à connaître 103
3. Les 9 CPS générales (Santé publique France, 2022) 103
4. Les pièges 103
5. Auto-test 103
6. Flashcards 104
Compléments du chapitre enrichi 104

Fiches-outils du chapitre 3 104
O3.1 – Recueil et analyse des représentations 105
O3.2 – Profil du public et adaptations 105
O3.3 – Grille « étapes du changement » 105
O3.4 – Planifier le développement des CPS 105
O3.5 – Règles du groupe et charte de bienveillance 106
O3.6 – Auto-observation de ma posture interculturelle 106

Fiche de révision du chapitre 3

Éléments de psychologie sociale



Carte mentale du chapitre 3

1. Les définitions à savoir

Notion	Définition	Auteur
Psychologie sociale	Influence des autres sur pensées, sentiments, comportements	Allport, 1954
Identité sociale	Partie de l'image de soi issue des groupes d'appartenance	Tajfel et Turner, 1979
Socialisation primaire / secondaire	Famille, enfance / école, pairs, travail, médias	–
Représentation sociale	Connaissance partagée ; noyau central + périphérie	Moscovici 1961, Abric
Acculturation	Changements liés au contact entre cultures ; spontanée / planifiée	Bastide ; Berry 1997
Dissonance cognitive	Inconfort de cognitions contradictoires → changement ou rationalisation	Festinger, 1957
Engagement	Lien entre la personne et ses actes (liberté, public, répété)	Kiesler ; Joule et Beauvois
CPS	Capacités cognitives, émotionnelles, sociales	Santé publique France, 2022
Efficacité personnelle	Croyance en sa capacité d'agir	Bandura, 1977

Notion	Définition	Auteur
Stigmatisation	Réduction d'une personne à un attribut disqualifiant	Goffman, 1963

2. Les modèles à connaître

Modèle	Contenu
Berry (1997)	Intégration, assimilation, séparation, marginalisation
Prochaska et DiClemente (1983)	Précontemplation, contemplation, préparation, action, maintien, rechute
Ajzen (1991)	Attitude + normes subjectives + contrôle perçu → intention → comportement
HBM	Vulnérabilité, gravité, bénéfices, obstacles, déclencheur, efficacité
Lewin (1943)	Discussion de groupe + décision collective ≈ 32 % vs conférence ≈ 3 %
Poulain (2002)	Espace social alimentaire : mangeable, système alimentaire, culinaire, consommation, temporalité, différenciation sociale

3. Les 9 CPS générales (Santé publique France, 2022)

- **Cognitives** : conscience de soi ; maîtrise de soi ; décisions constructives.
- **Émotionnelles** : conscience de ses émotions et de son stress ; régulation des émotions ; gestion du stress.
- **Sociales** : communication constructive ; relations constructives ; résolution des difficultés.

4. Les pièges

Attention

- Traiter une représentation comme une simple « erreur » à corriger.
- Imposer une **assimilation** (« manger à la française »).
- Utiliser des récompenses alimentaires ou forcer à goûter (néophobie).
- Parler de poids, peser en public, stigmatiser.
- Croire qu'informer suffit à faire changer.
- Afficher une norme descriptive défavorable (effet boomerang).

5. Auto-test

1. Qui a décrit le paradoxe de l'omnivore ? 2. Différence socialisation primaire / secondaire ? 3. Les 4 stratégies de Berry ? 4. Résultat de l'expérience de Lewin ? 5. Qu'est-ce que la dissonance cognitive ? 6. Les 3 catégories de CPS ? 7. Étape du changement d'une personne qui a changé depuis 2 mois ? 8. Les 3 déterminants de l'intention selon Ajzen ? 9. Combien d'expositions pour accepter un aliment ? 10. Source la plus puissante d'efficacité personnelle ? *Réponses : 1. Fischler (1990) – 2. Famille et enfance / école, pairs, travail, médias – 3. Intégration, assimilation, séparation, marginalisation – 4. ≈ 32 % (groupe) contre ≈ 3 % (conférence) – 5. Inconfort de cognitions contradictoires – 6. Cognitives, émotionnelles, sociales – 7. Action – 8. Attitude, normes subjectives, contrôle perçu – – 9. 8 à 15 – 10. Les expériences de réussite.*

6. Flashcards

Recto : Noyau central d'une représentation ?	Verso : Éléments stables et partagés, difficiles à changer ; on agit d'abord sur la périphérie
Recto : Acculturation planifiée ?	Verso : Changement culturel organisé par une institution (programme, cantine)
Recto : Pied-dans-la-porte ?	Verso : Obtenir un petit acte avant une demande plus importante
Recto : Néophobie : âge maximal ?	Verso : 2 à 6 ans
Recto : COM-B ?	Verso : Capacité, Opportunité, Motivation → Comportement (Michie, 2011)
Recto : Norme injonctive ?	Verso : Ce qu'il faut faire selon le groupe

Compléments du chapitre enrichi

Notion	À retenir
Communication	Palo Alto : on ne peut pas ne pas communiquer ; contenu et relation ; Mehrabian : pas de règle générale des 93 %
Écoute active	Rogers : empathie, acceptation, congruence ; reformulation, reflet, silence, synthèse ; Porter : 6 attitudes, privilégier la compréhension
Entretien motivationnel	Partenariat, acceptation, compassion, évocation ; ambivalence ; réflexe correcteur ; OuVER ; balance décisionnelle
Groupe	Tuckman : formation, turbulence, normalisation, production, dissolution ; Benne et Sheats ; Lewin, Lippitt et White
Motivation	Autodétermination : autonomie, compétence, affiliation ; éviter les récompenses alimentaires ; biais (présent, cadrage, halo, défaut)
Mesure	Likert (inverser : 6 – réponse) ; évocation hiérarchisée (fréquence, rang moyen ; noyau central probable)
COM-B	Capacité + opportunité + motivation → comportement ; fonctions : éducation, formation, persuasion, modélisation, environnement
L3	Identité sociale (Tajfel et Turner) ; goût de nécessité / de liberté (Bourdieu)

Fiches-outils du chapitre 3

Outil	Intitulé	Utilité
O3.1	Recueil et analyse des représentations d'un groupe	Partir des représentations du public
O3.2	Profil du public et adaptations	Adapter l'action à l'âge, la culture, la situation
O3.3	Grille « étapes du changement » et réponses éducatives	Adapter son discours à chaque personne
O3.4	Planifier le développement des CPS dans une action	Intégrer les CPS au projet
O3.5	Règles du groupe et charte de bienveillance	Créer un climat sécurisant
O3.6	Auto-observation de ma posture interculturelle	Décentration, C3.5

O3.1 – Recueil et analyse des représentations

Groupe, date, effectif

Technique utilisée (associations libres, photolangage, abaque de Régnier, classement)

Consigne donnée

Mots, idées, propos recueillis (sans nom)	Thème (prix, plaisir, santé, temps, culture, corps…)	Noyau (partagé) ou périphérie (variable) ?

Conséquences pour mes messages et mes activités

O3.2 – Profil du public et adaptations

Caractéristique	Ce que j'ai observé	Adaptation prévue
Âge, stade de développement		
Cultures, langues, pratiques religieuses		
Situation sociale et économique		
Compétences culinaires, équipement		
Littératie, rapport à l'écrit et au numérique		
Handicap, besoins particuliers		
Représentations dominantes		
Dynamique du groupe (leaders, tensions)		

O3.3 – Grille « étapes du changement »

Étape	Indices (ce que dit la personne)	Réponse éducative adaptée
Précontemplation	« Je n'ai pas de problème »	Informer sans braquer, susciter la curiosité
Contemplation	« Je devrais, mais… »	Explorer l'ambivalence, balance décisionnelle
Préparation	« Je vais commencer… »	Objectif concret, plan, ressources
Action (< 6 mois)	« Je fais… depuis… »	Valoriser, résoudre les obstacles
Maintien (> 6 mois)	« Je continue »	Prévenir la rechute, varier
Rechute	« J'ai repris… »	Dédramatiser, analyser, relancer

O3.4 – Planifier le développement des CPS

Catégorie	CPS visée	Activité prévue (séance, durée)	Indicateur d'observation
Cognitive			
Cognitive			
Émotionnelle			
Émotionnelle			
Sociale			
Sociale			

O3.5 – Règles du groupe et charte de bienveillance

Consigne

Construisez les règles **avec** le groupe lors de la première séance ; affichez-les ; rappelez-les si besoin.

☐	On a le droit de ne pas aimer et de ne pas goûter.
☐	On ne se moque pas : ni des goûts, ni du corps, ni de la façon de parler.
☐	Ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe.
☐	Chacun parle à son tour ; on écoute.
☐	On respecte les pratiques et les cultures de chacun.
☐	Pas de photo sans accord.
☐	On respecte les règles d'hygiène et de sécurité.
☐	(règle ajoutée par le groupe)
☐	(règle ajoutée par le groupe)

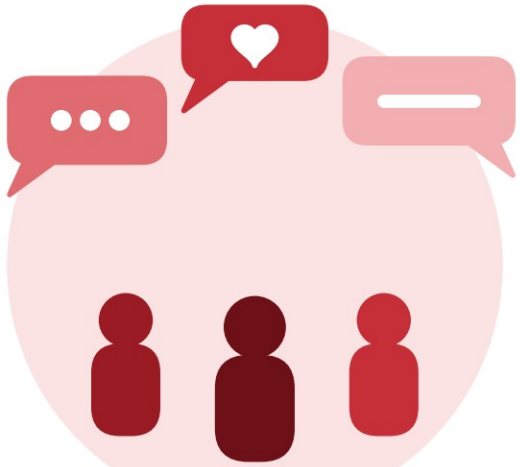
O3.6 – Auto-observation de ma posture interculturelle

Question	Ma réponse
Quelles sont mes propres normes alimentaires (repas «	
normal », horaires, aliments) ?	
Quelle situation m'a surpris(e) ou choqué(e) ? Pourquoi ?	
(décentration)	
Qu'ai-je appris de la culture de l'autre ? Comment me	
suis-je renseigné(e) ?	
Quel compromis ai-je négocié entre recommandations et	
pratiques de la personne ?	
Ce que je ferai différemment la prochaine fois	

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES



CHAPITRE

03

Éléments de psychologie sociale

Psychologie | Sociologie | Anthropologie de l'alimentation

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 3 110
Mode d'emploi du cahier 110
Partie 1 – Regards sur le mangeur, socialisation et identité 111
Exercice 3.1 – Légender les trois regards sur le mangeur (8 points) 112
Exercice 3.2 – Le paradoxe de l'omnivore et le principe d'incorporation (10 points) 113
Exercice 3.3 – Légender la socialisation alimentaire (8 points) 115
Exercice 3.4 – L'espace social alimentaire de Poulain (10 points) 117
Exercice 3.5 – Repas en famille et position sociale (12 points) 118
Exercice 3.6 – L'internat d'un lycée agricole (16 points) 120
Corrigés de la partie 1 122
Partie 2 – Représentations, normes, valeurs et culture 125
Exercice 3.7 – Représentations sociales : définition, formation, fonctions (10 points) 126
Exercice 3.8 – Normes descriptives et injonctives (10 points) 127
Exercice 3.9 – Légender les stratégies d'acculturation (10 points) 128
Exercice 3.10 – Analyse prototypique : « manger bio » chez des étudiants (14 points) 130
Exercice 3.11 – Une situation interculturelle à la cantine (12 points) 132
Exercice 3.12 – Questionnaire de mise en cause : qu'est-ce qu'un « vrai repas » ? (16 points) 133
Corrigés de la partie 2 135
Partie 3 – Influence sociale, attitudes et stigmatisation 138
Exercice 3.13 – Les grandes expériences de l'influence sociale (10 points) 139
Exercice 3.14 – L'expérience de Lewin (1943) et le travail en groupe (12 points) 140
Exercice 3.15 – Légender la dissonance cognitive (10 points) 142
Exercice 3.16 – Engagement et pied-dans-la-porte (12 points) 144
Exercice 3.17 – Légender stéréotype, préjugé, discrimination (12 points) 146
Exercice 3.18 – Mesurer les attitudes envers les personnes obèses (16 points) 148
Corrigés de la partie 3 150
Partie 4 – Compétences psychosociales, émotions, image du corps et estime de soi 153
Exercice 3.19 – Légender les compétences psychosociales (12 points) 154
Exercice 3.20 – Construire une séance CPS « explicite » (12 points) 156
Exercice 3.21 – Estime de soi : coter une échelle (12 points) 157
Exercice 3.22 – Insatisfaction corporelle et silhouettes (14 points) 158
Exercice 3.23 – Faim physiologique et faim émotionnelle (10 points) 160
Exercice 3.24 – Un programme CPS et nutrition au collège (16 points) 161
Corrigés de la partie 4 163
Partie 5 – Les modèles du changement de comportement 166
Exercice 3.25 – Légender les stades du changement (12 points) 167
Exercice 3.26 – Légender la théorie du comportement planifié (10 points) 169
Exercice 3.27 – Le modèle des croyances relatives à la santé (10 points) 171
Exercice 3.28 – Les quatre sources du sentiment d'efficacité personnelle (10 points) 172
Exercice 3.29 – Légender COM-B et choisir des fonctions d'intervention (14 points) 173
Exercice 3.30 – Évaluer un programme avec les stades du changement (16 points) 175
Corrigés de la partie 5 177
Partie 6 – Communiquer, écouter, accompagner la motivation 180
Exercice 3.31 – Légender le schéma de la communication (10 points) 181
Exercice 3.32 – Reconnaître les attitudes de Porter (12 points) 183
Exercice 3.33 – Questions ouvertes et reformulations (12 points) 184
Exercice 3.34 – Discours-changement et esprit de l'entretien motivationnel (12 points) 186
Exercice 3.35 – Construire une balance décisionnelle (12 points) 188

Exercice 3.36 – Analyser un entretien avec des indicateurs (16 points) 190
Corrigés de la partie 6 192

Partie 7 – Animer un groupe, motiver, tenir compte des biais de décision 194
Exercice 3.37 – Légender les étapes de la vie d'un groupe (10 points) 195
Exercice 3.38 – Les rôles dans un groupe (10 points) 197
Exercice 3.39 – Styles d'animation et participation (12 points) 198
Exercice 3.40 – Choisir une technique d'animation (12 points) 199
Exercice 3.41 – Motivation, biais et coups de pouce à la cantine (14 points) 200
Exercice 3.42 – Animer un groupe difficile (16 points) 202
Corrigés de la partie 7 203

Partie 8 – Mesurer les attitudes et les représentations ; cas complet 206
Exercice 3.43 – Repérer les erreurs dans des items (10 points) 207
Exercice 3.44 – Coter une échelle de Likert (12 points) 208
Exercice 3.45 – Le différenciateur sémantique : légumineuses et pâtes (12 points) 209
Exercice 3.46 – Analyse de contenu d'entretiens (12 points) 211
Exercice 3.47 – Comparer deux proportions avant et après un cycle d'ateliers (12 points) 213
Exercice 3.48 – Cas complet : les gardes de nuit d'une caserne de sapeurs-pompiers (40 points) 214
Corrigés de la partie 8 217

Bilan : grille d'auto-évaluation 220

Cahier d'exercices – Chapitre 3

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 3 : regards de la psychologie, de la sociologie et de l'anthropologie sur le mangeur, socialisation et identité, représentations, normes et valeurs, culture et interculturalité, influence sociale, attitudes et dissonance, stéréotypes et stigmatisation, compétences psychosociales, image corporelle et estime de soi, modèles du changement de comportement, communication et écoute, entretien motivationnel, animation de groupe, motivation et biais de décision (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition » et C3.5 « Communiquer et interagir dans un contexte d'intervention en santé », savoirs associés « Psychologie sociale » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : trois regards sur le mangeur, socialisation, stratégies d'acculturation de Berry, dissonance cognitive, stéréotype-préjugé-discrimination, compétences psychosociales, stades du changement, théorie du comportement planifié, modèle COM-B, schéma de la communication, étapes de la vie d'un groupe.
- Recueillir et analyser des représentations et des attitudes : évocation hiérarchisée, questionnaire de mise en cause, échelle de Likert, échelle d'estime de soi, silhouettes, différenciateur sémantique, analyse de contenu.
- Choisir des leviers d'action cohérents avec un diagnostic psychosocial, sans culpabiliser ni stigmatiser.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits d'entretiens), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes et chiffres des enquêtes locales sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les auteurs, les théories, les textes officiels et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026 ; chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés.

Méthode – Utiliser un concept de psychologie sociale à l'examen

Pour chaque concept, écrivez trois éléments : la définition avec l'auteur et l'année, l'application à la situation (une citation ou un chiffre du document), puis la conséquence pour l'action (« donc je propose… »). Un concept cité sans application ne rapporte presque pas de points ; une action proposée sans concept non plus.

Partie 1 – Regards sur le mangeur, socialisation et identité

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer les regards de la psychologie, de la sociologie, de l'anthropologie et de la psychologie sociale sur l'alimentation.
- Expliquer le paradoxe de l'omnivore et le principe d'incorporation (Fischler, 1990), l'espace social alimentaire (Poulain, 2002).
- Définir la socialisation primaire et secondaire et l'identité sociale ; les relier aux pratiques alimentaires d'un public.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Psychologie sociale : étude de la façon dont les pensées, les émotions et les comportements d'une personne sont influencés par la présence réelle, imaginée ou implicite des autres (Allport, 1954).
- Paradoxe de l'omnivore (Fischler, 1990) : l'être humain a besoin de varier son alimentation (néophilie) mais se méfie des aliments inconnus (néophobie). Principe d'incorporation : « on devient ce que l'on mange » ; manger un aliment, c'est faire entrer en soi ses qualités réelles ou imaginées.
- Espace social alimentaire (Poulain, 2002) : six dimensions qui montrent la liberté et les contraintes du mangeur : l'ordre du mangeable, le système alimentaire, l'espace culinaire, l'espace des habitudes de consommation, la temporalité alimentaire, l'espace de différenciation sociale.
- Socialisation : processus par lequel une personne apprend et intériorise les normes et les valeurs de son groupe. Primaire (enfance : famille, école) ; secondaire (vie adulte : pairs, travail, couple, médias).
- Identité sociale (Tajfel et Turner, 1979) : partie de l'image de soi qui vient de l'appartenance à des groupes ; on cherche à valoriser son groupe (endogroupe) par rapport aux autres (exogroupes).

Exercice 3.1 – Légender les trois regards sur le mangeur (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous présentez le chapitre « psychologie sociale » à des étudiants de première année en santé. Vous voulez leur montrer qu'un même comportement alimentaire peut être étudié par plusieurs disciplines.

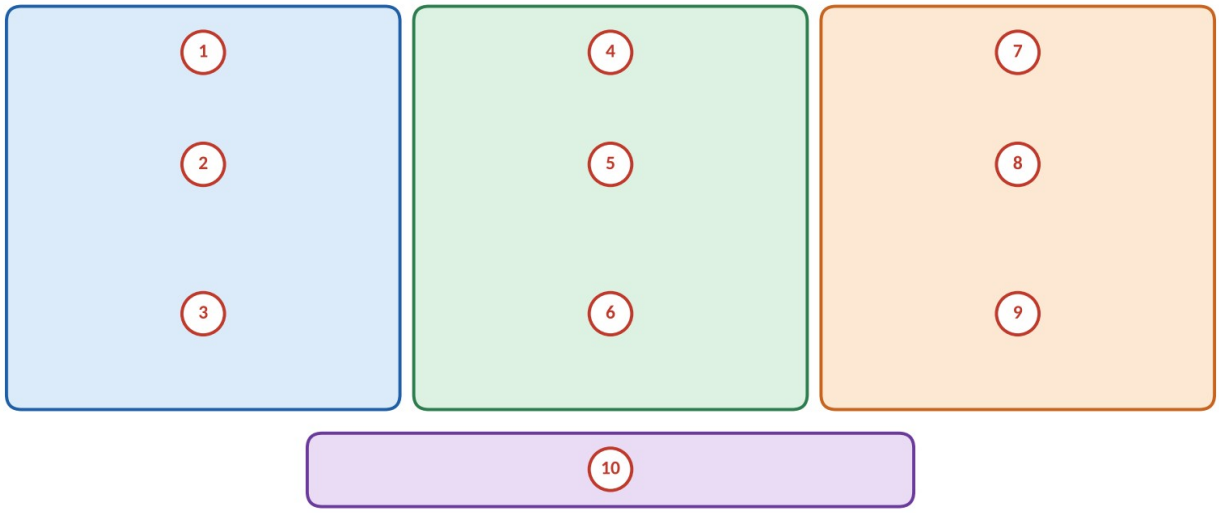


Figure 3.1 – Document 1 – Trois regards sur le mangeur (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (5 pts)
2. Pour le comportement « une adolescente refuse de manger à la cantine », formulez une question que poserait chacune des trois disciplines. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.2 – Le paradoxe de l'omnivore et le principe d'incorporation (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez un stage dans une crèche municipale. Les auxiliaires de puériculture vous rapportent des remarques d'enfants et de parents pendant la semaine du goût.

Document 1 – Ce qu'on entend à la crèche

a) Léna, 3 ans, repousse la purée de patate douce : « C'est orange, je veux pas. »

b) Un père : « Mon fils mange de la viande rouge pour devenir costaud. »

c) Malik, 4 ans, goûte le fenouil pour la troisième fois et dit : « Ça, j'aime bien maintenant. »

d) Une mère : « Je ne lui donne pas de lapin, c'est un animal de compagnie chez nous. »

e) Une auxiliaire : « Les enfants veulent tous goûter le plat que la cuisinière a appelé "la potion du dragon". »

f) Une mère végétarienne : « Je ne veux pas que mon enfant mange de la souffrance animale. »

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez le paradoxe de l'omnivore en citant l'auteur et l'année. (2 pts)
2. Classez chaque situation du document 1 : néophobie, néophilie ou exposition répétée, principe d'incorporation, ordre du mangeable. (4 pts)
3. Proposez deux pratiques de la crèche qui s'appuient sur ces notions pour faire accepter un légume nouveau. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi il ne faut pas forcer un enfant à finir un aliment nouveau. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.3 – Légender la socialisation alimentaire (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une conseillère en économie sociale et familiale vous demande d'expliquer pourquoi des jeunes qui quittent le domicile familial changent si vite d'habitudes alimentaires.

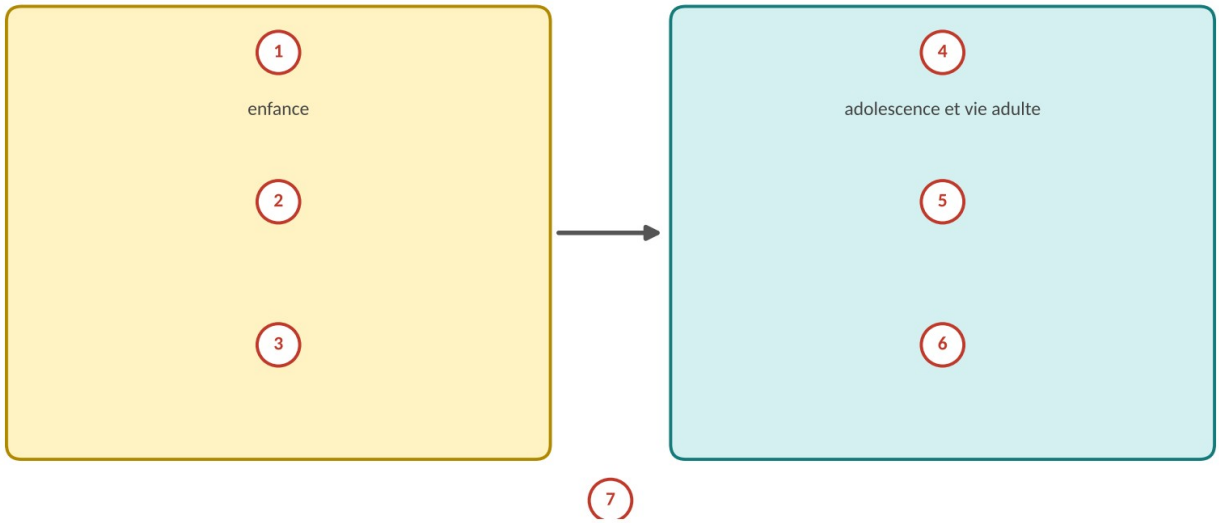


Figure 3.2 – Document 1 – Socialisation primaire et secondaire (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)
2. Classez les agents suivants en agents de socialisation primaire ou secondaire : grands-parents, collègues de travail, assistante maternelle, influenceur culinaire, conjoint, cantine de l'école élémentaire, club de sport. (2,5 pts)
3. Expliquez, avec ce schéma, le changement d'habitudes d'un étudiant qui quitte ses parents pour une résidence universitaire. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.4 – L'espace social alimentaire de Poulain (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un atelier dans un foyer de travailleurs migrants qui accueille principalement des hommes de 45 à 70 ans, originaires d'Afrique de l'Ouest. Le responsable vous a transmis ses observations.

Document 1 – Observations du responsable du foyer

a) Les résidents ne mangent jamais de porc ; certains évitent aussi le gibier.

b) Les produits de base (riz brisé, huile d'arachide, poisson séché) sont achetés dans deux épiceries spécialisées du quartier.

c) Les plats sont cuisinés en grande marmite dans la cuisine collective, souvent par les plus âgés.

d) On mange en groupe, autour d'un plat commun, assis par terre ou à la table de la salle commune.

e) Le repas principal est pris tard le soir, après le travail ; pendant le ramadan, les horaires changent.

f) Les résidents disent que manger « comme au pays » les distingue des jeunes du quartier, qui mangent « des sandwichs ».

À vous de jouer – Questions

1. Citez les six dimensions de l'espace social alimentaire (Poulain, 2002). (3 pts)
2. Associez chaque observation du document 1 à une dimension. (3 pts)
3. Montrez en quoi ce modèle aide à éviter un atelier « hors sol ». Donnez deux adaptations concrètes. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.5 – Repas en famille et position sociale (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre d'un projet « bien manger » d'une école élémentaire, l'association des parents d'élèves a fait remplir un questionnaire par les familles. Vous êtes chargé d'analyser une question.

Document 1 – « Dans votre foyer, prenez-vous le repas du soir ensemble, à table, au moins 5 soirs sur 7 ? » (données fictives)

Profession de la personne de référence du foyer	Familles répondantes	Réponses « oui »
Cadres et professions intellectuelles supérieures	80	62
Employés	110	70
Ouvriers	90	48
Sans emploi	60	30
Total	340	210

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de « oui » dans chaque groupe et pour l'ensemble. (3 pts)
2. Calculez le rapport entre le pourcentage des cadres et celui des ouvriers ; rédigez une phrase d'interprétation. (2 pts)
3. Proposez trois explications sociologiques de ces écarts (horaires, conditions de travail, logement, normes). Évitez toute explication qui culpabilise les familles. (4 pts)
4. Indiquez deux limites de ces données. (2 pts)
5. Indiquez ce que ce résultat change pour le projet de l'école. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.6 – L'internat d'un lycée agricole (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au lycée agricole de Montfaucon (données fictives). Le service de restauration constate que les 120 élèves internes de seconde, arrivés en septembre, laissent beaucoup de nourriture, surtout les jours où les plats sont nouveaux pour eux. L'infirmière signale des élèves qui « ne mangent que du pain » et qui disent avoir le mal du pays. Le chef de cuisine vous demande une analyse avant de changer les menus.

Document 1 – Pesées des restes dans les assiettes, septembre et octobre (données fictives)

Type de plat principal	Nombre de repas observés	Restes totaux	Exemples
Plats connus des élèves	1 200	108 kg	steak haché-frites, pâtes bolognaise, poulet rôti
Plats nouveaux pour eux	960	201,6 kg	tajine de légumes, gratin de blettes, poisson en sauce

Document 2 – Ce que disent des internes

« Chez moi, on ne mange jamais de poisson. » « Ma mère fait le poulet comme personne. » « Ici on mange à 18 h 45, chez moi c'est 20 h devant la télé. » « Si tu prends les blettes, les autres rigolent. » « Le dimanche soir, j'ai le cafard. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les restes moyens par repas pour chaque type de plat (en grammes), puis le rapport entre les deux. (3 pts)
2. Analysez la situation avec trois notions : néophobie, socialisation primaire (repères familiaux), influence des pairs. Appuyez-vous sur le document 2. (5 pts)
3. Expliquez le lien entre le mal du pays et l'alimentation (fonction identitaire et affective des aliments). (2 pts)
4. Proposez quatre actions qui réduisent le gaspillage sans renoncer à la diversité des menus ; justifiez chacune par une notion. (4 pts)
5. Proposez un indicateur pour évaluer l'effet de vos actions en fin d'année. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 3.1

1. Légendes : 1 Psychologie ; 2 l'individu : perceptions, émotions, motivations, apprentissages ; 3 Pourquoi cette personne refuse-t-elle les légumes ? ; 4 Sociologie ; 5 les groupes sociaux : normes, classes sociales, genre, âge ; 6 Pourquoi les ouvriers mangent-ils moins de fruits que les cadres ? ; 7 Anthropologie ; 8 les cultures : symboles, rituels, interdits, manières de table ; 9 Pourquoi le repas partagé compte-t-il autant en France ? ; 10 Psychologie sociale : l'individu dans ses relations aux autres.
2. Psychologie : quelles émotions, quels dégoûts ou quelle image de son corps expliquent son refus ? Sociologie : le refus est-il plus fréquent dans certains milieux sociaux, chez les filles, à certains âges, et que dit-il des normes du groupe ? Anthropologie : quels aliments servis à la cantine sont jugés « mangeables » ou interdits dans sa culture familiale ? On peut ajouter la psychologie sociale : l'adolescente refuse-t-elle pour se conformer à son groupe d'amies ?

Corrigé – Exercice 3.2

1. Claude Fischler (L'Homnivore, 1990) : l'omnivore dépend d'une grande variété d'aliments, ce qui le pousse à essayer du nouveau (néophilie) ; mais tout aliment inconnu peut être dangereux, ce qui le rend prudent (néophobie). Cette tension crée une anxiété que la culture apaise en disant ce qui se mange et comment.
2. a) néophobie (refus lié à l'aspect, sans avoir goûté) ; b) principe d'incorporation (on attend de la viande qu'elle transmette la force) ; c) exposition répétée : l'acceptation augmente avec le nombre de dégustations ; d) ordre du mangeable : un animal de compagnie n'est pas « mangeable » dans cette culture familiale ; e) néophilie favorisée par un nom ludique et la curiosité ; f) principe d'incorporation dans sa dimension morale (on ne veut pas faire entrer en soi la souffrance), et ordre du mangeable.
3. Proposer le légume plusieurs fois (8 à 10 expositions sont souvent nécessaires) en petites quantités, sans pression ; le faire manipuler, sentir et nommer de façon ludique ; montrer les adultes et d'autres enfants qui en mangent avec plaisir (modèle).
4. La contrainte associe l'aliment à une émotion négative et renforce le refus ; elle peut créer un dégoût durable. Elle apprend aussi à l'enfant à ne plus écouter ses signaux de faim et de satiété. La règle conseillée est « on goûte, on n'est pas obligé de finir ».

Corrigé – Exercice 3.3

1. Légendes : 1 Socialisation primaire ; 2 Agents : famille, école maternelle et élémentaire ; 3 Ce qui est appris : goûts, manières de table, rythme des repas, ce qui « se mange » ; 4 Socialisation secondaire ; 5 Agents : pairs, travail, couple, médias, réseaux sociaux ; 6 Ce qui change : pratiques du groupe d'appartenance, horaires de travail, nouveaux aliments ; 7 Identité : ce que je mange dit qui je suis et à quel groupe j'appartiens.
2. Primaire : grands-parents, assistante maternelle, cantine de l'école élémentaire. Secondaire : collègues de travail, influenceur culinaire, conjoint, club de sport.
3. Chez ses parents, les repas suivaient les règles apprises pendant la socialisation primaire (horaires, plats, repas à table). En résidence, il n'a plus ce cadre ; les nouveaux agents (amis étudiants, horaires des cours, réseaux sociaux, petit budget, cuisine partagée) imposent d'autres normes : repas décalés ou sautés, plats rapides, repas pris en groupe le soir. Les habitudes de l'enfance ne disparaissent pas : elles reviennent souvent quand l'étudiant s'installe en couple ou devient parent.

Corrigé – Exercice 3.4

1. L'ordre du mangeable ; le système alimentaire ; l'espace culinaire ; l'espace des habitudes de consommation ; la temporalité alimentaire ; l'espace de différenciation sociale.
2. a) ordre du mangeable (interdits religieux et culturels) ; b) système alimentaire (filières

d'approvisionnement, commerces) ; c) espace culinaire (où et qui cuisine, techniques) ; d) habitudes de consommation (manières de table, plat commun) ; e) temporalité alimentaire (horaires, calendrier religieux) ; f) différenciation sociale (l'alimentation marque l'appartenance à un groupe et la distinction des autres).

3. Le modèle oblige à partir des pratiques réelles, de leurs contraintes et de leur sens avant de proposer quelque chose. Un atelier « hors sol » proposerait par exemple une recette avec du porc, un repas à midi un jour de ramadan ou des produits introuvables dans le quartier. Adaptations : partir d'un plat que les résidents cuisinent déjà (mafé, thieboudienne) et travailler avec eux une version moins grasse ou moins salée en gardant le goût (huile, cube de bouillon) ; organiser l'atelier le soir, en grande marmite, avec les cuisiniers du foyer, et acheter les produits dans les épiceries du quartier. On valorise ainsi leur identité au lieu de la nier.

Corrigé – Exercice 3.5

1. Cadres : 62 / 80 × 100 = 77,5 % ; employés : 70 / 110 × 100 = 63,6 % ; ouvriers : 48 / 90 × 100 = 53,3 % ; sans emploi : 30 / 60 × 100 = 50,0 % ; ensemble : 210 / 340 × 100 = 61,8 %.

2. 77,5 / 53,3 = 1,45. Dans cette école, les familles de cadres déclarent 1,45 fois plus souvent que les familles d'ouvriers un repas du soir pris ensemble au moins 5 soirs sur 7.

3. Horaires et conditions de travail : travail posté, de nuit ou en horaires décalés plus fréquent chez les ouvriers et certains employés, qui empêche d'être présent le soir. Logement : logements plus petits, sans place pour une table commune, repas pris à tour de rôle. Organisation familiale : familles monoparentales, plusieurs emplois. Normes : le repas familial à table est une norme très valorisée dans les milieux favorisés, qui peuvent aussi mieux la respecter ; dans d'autres milieux, le repas devant la télévision ou en décalé n'a pas le même sens. Ces explications portent sur les conditions de vie, pas sur la « volonté » des parents.

4. Données déclaratives (désirabilité sociale : le repas en famille est une norme, on peut surestimer) ; familles volontaires, sans taux de réponse connu ; petits effectifs ; une seule profession par foyer ; pas de test statistique.

5. Ne pas faire du « repas en famille » une injonction qui culpabiliserait les parents qui travaillent tard ; proposer plutôt des idées de repas rapides à partager quand c'est possible, et valoriser d'autres moments (petit-déjeuner, week-end).

Corrigé – Exercice 3.6

1. Plats connus : 108 kg = 108 000 g ; 108 000 / 1 200 = 90 g par repas. Plats nouveaux : 201 600 / 960 = 210 g par repas. Rapport : 210 / 90 = 2,33. Les plats nouveaux laissent 2,3 fois plus de restes que les plats connus.

2. Néophobie : les plats inconnus (tajine de légumes, blettes, poisson en sauce) inquiètent ; les élèves préfèrent ce qui est familier, surtout dans une période de stress (arrivée à l'internat). Socialisation primaire : les repères familiaux restent forts (« chez moi, on ne mange jamais de poisson », horaires de 20 h, poulet « de ma mère ») ; le changement d'horaires et de plats bouleverse leurs habitudes. Influence des pairs : à 15 ans, le regard du groupe compte beaucoup (« si tu prends les blettes, les autres rigolent ») ; personne ne veut être le premier à goûter.

3. Les aliments familiaux sont associés à la maison, à la mère, à la sécurité affective ; manger « comme chez soi » rassure et confirme son identité. Loin de chez eux, les élèves recherchent ce qui est connu (pain, plats habituels) et refusent ce qui rappelle qu'ils sont ailleurs.

4. Exemples : proposer chaque nouveau plat en petite portion à côté d'un plat connu, et le reproposer plusieurs fois (exposition répétée) ; organiser une dégustation commentée par le chef, avec un nom attractif (néophilie) ; faire participer des élèves volontaires à l'élaboration d'un menu par mois (implication, engagement) ; impliquer des élèves de terminale comme modèles (influence des pairs, norme descriptive) ; proposer un « plat de chez nous » choisi par les élèves une fois par semaine

(identité, sécurité affective).

5. Restes moyens par repas pour les plats nouveaux, mesurés avec la même méthode en mai : objectif de passer de 210 g à moins de 150 g ; ou la part des élèves qui goûtent un plat nouveau, relevée lors de dégustations.

Partie 2 – Représentations, normes, valeurs et culture

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir une représentation sociale, ses processus de formation (objectivation, ancrage) et ses fonctions ; distinguer noyau central et éléments périphériques.
- Distinguer norme, valeur et attitude ; norme descriptive et norme injonctive.
- Analyser une situation interculturelle (Berry, Cohen-Emerique) sans ethnocentrisme.
- Réaliser une analyse prototypique et un questionnaire de mise en cause.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Représentation sociale : forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, qui vise un but pratique et contribue à construire une réalité commune à un groupe (Jodelet, 1989, d'après Moscovici, 1961).
- Objectivation : rendre concret une notion abstraite (« manger sain » devient « manger des légumes verts »). Ancrage : rattacher la nouveauté à des catégories déjà connues (« le bio, c'est comme les produits de la ferme »).
- Fonctions (Abric, 1994) : de savoir, identitaire, d'orientation des conduites, justificatrice.
- Théorie du noyau central (Abric, 1976, 1994) : le noyau, stable et consensuel, donne le sens ; la périphérie, souple, s'adapte aux situations et protège le noyau.
- Norme : règle de conduite partagée par un groupe. Norme descriptive : ce que font la plupart des gens. Norme injonctive : ce qu'il faut faire, ce qui est approuvé (Cialdini, Reno et Kallgren, 1990). Valeur : idéal qui oriente les choix (santé, plaisir, partage, économie).
- Acculturation (Berry, 1997) : intégration, assimilation, séparation, marginalisation.
- Démarche interculturelle (Cohen-Emerique) : décentration, découverte du cadre de référence de l'autre, négociation.

Exercice 3.7 – Représentations sociales : définition, formation, fonctions (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne d'un centre de santé vous demande pourquoi certains patients disent : « Les féculents font grossir, je les ai supprimés. » Elle veut comprendre d'où viennent ces idées avant sa prochaine séance collective.

Document 1 – Extraits d'entretiens avec des patients

a) « Pour moi, maigrir, c'est manger de la salade et du blanc de poulet. »

b) « Le pain, c'est comme le sucre, ça se transforme en gras. »

c) « Dans ma famille, on a toujours dit que les pâtes, c'est pour les sportifs. »

d) « Si je mange des pâtes le soir, je me sens coupable, alors je les évite pour être tranquille. »

e) « Moi je fais attention, pas comme les gens qui mangent n'importe quoi. »

À vous de jouer – Questions

1. Définissez une représentation sociale en citant deux auteurs. (2 pts)
2. Montrez dans le document 1 un exemple d'objectivation et un exemple d'ancrage. (2 pts)
3. Associez les extraits c), d) et e) à une fonction des représentations (Abric, 1994). (3 pts)
4. Expliquez pourquoi une simple information (« les féculents ne font pas grossir ») a peu de chances de changer ces représentations, et proposez une autre démarche. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.8 – Normes descriptives et injonctives (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une entreprise veut inciter ses salariés à prendre le plat végétarien du restaurant d'entreprise. Le service communication a proposé plusieurs affiches et vous demande votre avis.

Document 1 – Projets d'affiches

A. « Il faut manger moins de viande pour la planète. »

B. « Seuls 8 % des salariés choisissent le plat végétarien : ne soyez pas comme les autres ! »

C. « Cette semaine, 1 salarié sur 3 a choisi le plat végétarien. Et vous ? »

D. « Vos collègues trouvent que le plat végétarien du jeudi est le meilleur de la semaine (note moyenne : 4,3 sur 5). »

E. « Le plat végétarien : délicieux, rassasiant, et préparé ici avec des produits locaux. »

À vous de jouer – Questions

1. Définissez norme, valeur et attitude. (3 pts)
2. Classez chaque affiche : norme injonctive, norme descriptive, ou message qui ne s'appuie pas sur une norme. (2,5 pts)
3. Expliquez pourquoi l'affiche B risque d'avoir l'effet inverse de celui recherché (effet « boomerang »). (2,5 pts)
4. Choisissez l'affiche la plus efficace et justifiez. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.9 – Légender les stratégies d'acculturation (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez des ateliers dans un centre d'accueil de personnes réfugiées. La coordinatrice vous présente quatre résidents.

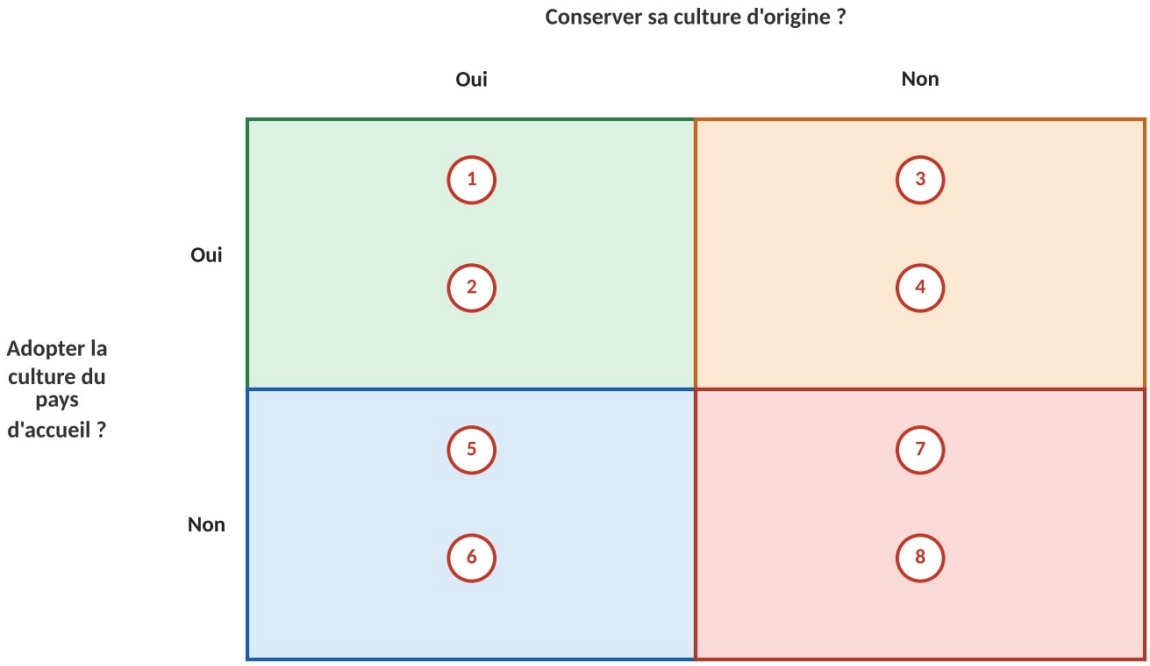


Figure 3.3 – Document 1 – Les stratégies d'acculturation de Berry (schéma à légender)

Document 2 – Quatre résidents

a) Nour, 34 ans, cuisine les plats syriens de sa mère et a appris à faire les gratins avec ses voisines.

b) Arman, 52 ans, ne mange que des produits de son pays, achetés dans une épicerie spécialisée ; il refuse la cantine de l'entreprise.

c) Yusuf, 19 ans, dit qu'il « ne mange plus comme là-bas » mais qu'il ne sait pas cuisiner « à la française » : il vit de sandwichs.

d) Aïcha, 27 ans, mange comme ses collègues françaises et a cessé de préparer les plats de son enfance.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Associez chaque résident à une stratégie. (2 pts)
3. Indiquez la situation la plus à risque pour la santé et expliquez pourquoi. (2 pts)
4. Indiquez ce que doit viser un atelier pour ce public, d'après ce modèle. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.10 – Analyse prototypique : « manger bio » chez des étudiants (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de santé étudiante d'une université veut développer l'offre de produits biologiques à la cafétéria. Vous avez recueilli les représentations de 90 étudiants par évocation hiérarchisée : « Quels sont les cinq mots qui vous viennent à l'esprit quand on vous dit "manger bio" ? Classez-les du plus important (1) au moins important (5). »

Document 1 – Résultats (données fictives)

Catégorie	Nombre de citations	Rang moyen
Santé	54	2,0
Cher	49	2,3
Nature	36	2,9
Sans pesticides	33	2,5
Local	25	3,6
Goût	22	3,4
Mode, « bobo »	18	2,6
Marketing	12	3,8

Seuils : moyenne des citations et moyenne des rangs moyens des huit catégories.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les deux seuils. (2 pts)

2. Construisez le tableau à quatre zones et placez chaque catégorie. (4 pts)

3. Interprétez la représentation : sens du noyau, rôle de la périphérie, zone contrastée. (4 pts)

4. Déduisez-en deux recommandations pour l'offre de la cafétéria et sa communication. (2 pts)

5. Indiquez comment vérifier qu'un élément appartient vraiment au noyau. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.11 – Une situation interculturelle à la cantine (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans un service municipal de restauration scolaire. Une animatrice périscolaire vous raconte : « Une maman est venue se plaindre parce que sa fille ne mange rien les jours où il y a de la viande. Je lui ai dit qu'en France, on mange de tout et que sa fille devait s'adapter. Elle est partie en colère. » La commune propose déjà un menu sans viande une fois par semaine.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez l'ethnocentrisme et le relativisme culturel. (2 pts)
2. Analysez la réaction de l'animatrice : quelle attitude montre-t-elle ? Quelles conséquences pour l'enfant et pour la relation avec la famille ? (3 pts)
3. Présentez les trois étapes de la démarche interculturelle de Margalit Cohen-Emerique et appliquez-les à cette situation. (5 pts)
4. Proposez deux solutions concrètes qui respectent le cadre de la restauration scolaire et les besoins de l'enfant. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.12 – Questionnaire de mise en cause : qu'est-ce qu'un « vrai repas » ? (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de quartier veut lancer des ateliers « repas rapides et équilibrés » pour des parents qui travaillent. Lors d'une première enquête par évocation, les mots « plat chaud », « à table », « en famille », « pain » et « dessert » sont apparus dans la zone du noyau. Pour vérifier leur centralité, vous réalisez un questionnaire de mise en cause auprès de 120 habitants.

Document 1 – Résultats du questionnaire de mise en cause (données fictives)

Question posée pour chaque élément : « Un repas peut-il être un vrai repas s'il… »

Élément mis en cause	Réponses « non » (n = 120)
… ne comporte pas de plat chaud ?	98
… n'est pas pris assis à table ?	101
… est pris seul ?	88
… ne comporte pas de pain ?	52
… ne comporte pas de dessert ?	31

Règle de décision : un élément est considéré comme central si au moins 75 % des personnes refusent qu'on puisse le retirer (réponse « non »).

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez le principe du questionnaire de mise en cause. (2 pts)
2. Calculez le pourcentage de « non » pour chaque élément et appliquez la règle de décision. (5 pts)
3. Interprétez : quels éléments font partie du noyau, lesquels sont périphériques ? Discutez le cas de « pris seul ». (3 pts)
4. Déduisez-en deux conséquences pour les ateliers « repas rapides ». (4 pts)
5. Indiquez deux limites de cette méthode. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 3.7

1. Selon Denise Jodelet (1989), qui prolonge les travaux de Serge Moscovici (1961), une représentation sociale est une forme de connaissance socialement élaborée et partagée, qui a un but pratique et contribue à construire une réalité commune à un groupe. C'est une « théorie du sens commun » qui guide les conduites.
2. Objectivation : a) « maigrir, c'est manger de la salade et du blanc de poulet » rend concrète l'idée abstraite de régime. Ancrage : b) « le pain, c'est comme le sucre » rattache le pain, mal connu, à une catégorie déjà connue et jugée négative.
3. c) fonction de savoir (et identitaire : un savoir transmis dans la famille) ; d) fonction justificatrice (l'évitement est justifié après coup, pour se sentir en accord avec soi) ; e) fonction identitaire (se situer dans le groupe de « ceux qui font attention », se distinguer des autres).
4. Une représentation n'est pas une simple erreur de connaissance : elle est partagée, elle a un sens pour le groupe et elle protège l'identité ; le noyau résiste aux contre-arguments. On peut plutôt partir de ce que pensent les patients (photolangage, débat), les faire expérimenter (une assiette avec féculents, sensation de satiété), utiliser des pairs qui ont réussi, et agir d'abord sur les éléments périphériques (« le soir, une petite portion de féculents aide à éviter le grignotage »).

Corrigé – Exercice 3.8

1. Norme : règle de conduite partagée par un groupe, dont le non-respect entraîne une sanction sociale (moquerie, rejet). Valeur : idéal collectif qui oriente les choix et donne du sens (santé, écologie, plaisir). Attitude : disposition interne, plus ou moins favorable, envers un objet (j'aime ou je n'aime pas les plats végétariens), qui prépare à agir.
2. A : norme injonctive (ce qu'il faut faire). B : norme descriptive négative (ce que fait la majorité : ne pas choisir le plat végétarien). C : norme descriptive positive et en progression. D : norme injonctive sociale (ce qu'approuvent les collègues). E : message centré sur les qualités du plat, sans norme sociale.
3. L'affiche B dit que 92 % des salariés ne prennent pas le plat végétarien : elle installe une norme descriptive contraire au but. Les gens ont tendance à se conformer à ce que fait la majorité ; ceux qui en prenaient déjà pourraient même en prendre moins. Les travaux de Cialdini (1990) et de Schultz et ses collègues (2007) montrent cet effet boomerang lorsqu'on décrit un comportement indésirable comme fréquent.
4. L'affiche C (ou D) : elle montre qu'un comportement est fréquent et approuvé par les collègues, ce qui active la norme descriptive et la norme injonctive dans le même sens. On peut combiner C et E pour ajouter le plaisir. L'affiche A, moralisatrice, risque de provoquer un rejet (réactance).

Corrigé – Exercice 3.9

1. Légendes : 1 Intégration ; 2 garder ses pratiques et adopter celles du pays d'accueil ; 3 Assimilation ; 4 abandonner ses pratiques pour celles du pays d'accueil ; 5 Séparation ; 6 garder ses pratiques sans adopter celles du pays d'accueil ; 7 Marginalisation ; 8 perdre ses pratiques sans adopter celles du pays d'accueil.
2. a) Nour : intégration ; b) Arman : séparation ; c) Yusuf : marginalisation ; d) Aïcha : assimilation.
3. La marginalisation (Yusuf) : il a perdu ses repères culinaires sans en acquérir de nouveaux ; son alimentation est monotone et dépend de produits tout prêts ; elle s'accompagne souvent d'un isolement social et d'une perte d'estime de soi. L'assimilation peut aussi exposer à une alimentation plus industrialisée, alors que certaines alimentations d'origine sont riches en légumineuses et en légumes.
4. Favoriser l'intégration : valoriser les savoir-faire d'origine (recettes, épices, légumineuses) et donner accès aux produits et repères du pays d'accueil (où acheter, à quel prix, comment cuisiner un légume local). Un atelier où chacun apporte une recette de chez lui et découvre une recette locale est un bon exemple.

Corrigé – Exercice 3.10

1. Total des citations : 54 + 49 + 36 + 33 + 25 + 22 + 18 + 12 = 249 ; seuil de fréquence = 249 / 8 = 31,1 citations. Somme des rangs : 2,0 + 2,3 + 2,9 + 2,5 + 3,6 + 3,4 + 2,6 + 3,8 = 23,1 ; seuil de rang = 23,1 / 8 = 2,89.

2. Zone du noyau (fréquence ≥ 31,1 et rang < 2,89) : santé (54 ; 2,0), cher (49 ; 2,3), sans pesticides (33 ; 2,5). Première périphérie (fréquence ≥ 31,1 et rang ≥ 2,89) : nature (36 ; 2,9). Zone contrastée (fréquence < 31,1 et rang < 2,89) : mode, « bobo » (18 ; 2,6). Seconde périphérie (fréquence < 31,1 et rang ≥ 2,89) : local (25 ; 3,6), goût (22 ; 3,4), marketing (12 ; 3,8).

3. Pour ces étudiants, manger bio, c'est d'abord manger sain, sans pesticides, mais cher : le noyau associe un bénéfice (santé) et un frein majeur (prix). La périphérie (nature, local, goût, marketing) est moins partagée ; elle montre des éléments qui peuvent évoluer, et une méfiance (marketing). La zone contrastée révèle un sous-groupe qui associe le bio à une mode sociale (« bobo ») : pour lui, manger bio marque une distinction sociale qu'il rejette peut-être.

4. Agir sur le prix, frein central : un plat bio au même prix que le plat habituel, des produits bruts bio peu chers (légumineuses, pommes) ; communiquer sur la santé et l'absence de pesticides, qui ont du sens pour eux, et éviter un discours « tendance » qui renforcerait l'image « bobo » ; montrer la provenance locale pour répondre à la méfiance envers le marketing.

5. Utiliser une seconde technique : questionnaire de mise en cause (« Peut-on parler de bio si ce n'est pas bon pour la santé ? »), schèmes cognitifs de base, ou entretiens. Un élément central est massivement refusé quand on le met en cause.

Corrigé – Exercice 3.11

1. Ethnocentrisme : tendance à juger les pratiques des autres groupes à partir des normes de son propre groupe, considérées comme les seules normales. Relativisme culturel : attitude qui considère que chaque pratique a un sens dans sa culture et qu'il faut la comprendre avant de la juger.

2. L'animatrice montre une attitude ethnocentrique (« en France, on mange de tout ») et une injonction à l'assimilation. Conséquences : l'enfant ne mange pas, peut avoir faim l'après-midi et se sentir rejetée ; la mère se sent jugée, la confiance avec l'école est rompue, la famille peut retirer l'enfant de la cantine, alors que la cantine est souvent le repas le plus complet de la journée pour certains enfants.

3. Décentration : l'animatrice prend conscience de son propre cadre de référence (pour elle, manger de tout est une valeur d'éducation et d'égalité) et de ses réactions. Découverte du cadre de référence de l'autre : elle écoute la mère, sans supposer : la viande est-elle refusée pour des raisons religieuses (viande non certifiée), végétariennes, de goût ? Négociation : chercher une solution acceptable pour les deux parties, dans le cadre du règlement de la cantine (par exemple, proposer à l'enfant les accompagnements en plus grande quantité et le menu sans viande de la semaine).

4. Servir systématiquement à l'enfant une double portion d'accompagnement (légumes, féculents) et le laitage les jours de viande, en lien avec la cuisine ; informer la famille du menu à l'avance ; étudier avec la commune une alternative protéique (œuf, poisson, légumineuses) lorsque c'est possible. La décision appartient à la commune, mais la relation de confiance dépend de la façon d'en parler.

Corrigé – Exercice 3.12

1. On présente chaque élément supposé central et on demande si l'objet existe encore sans lui (Moliner, 1988). Si une large majorité répond que non, l'élément est indispensable au sens de l'objet : il est central. Si beaucoup acceptent qu'on le retire, il est périphérique.

2. Plat chaud : 98 / 120 × 100 = 81,7 % ; assis à table : 101 / 120 × 100 = 84,2 % ; pris seul : 88 / 120 × 100 = 73,3 % ; pain : 52 / 120 × 100 = 43,3 % ; dessert : 31 / 120 × 100 = 25,8 %. Au seuil de 75 % : plat chaud et à table sont centraux ; pris seul, pain et dessert ne sont pas centraux.

3. Le noyau du « vrai repas » pour ces habitants est un plat chaud pris assis à table. Le pain et le dessert sont périphériques : ils sont fréquents mais on peut s'en passer. « Pris seul » (73,3 %) est juste sous le seuil : la

dimension sociale du repas est forte mais pas unanime ; c'est un élément à la frontière, que d'autres techniques devraient confirmer.

4. Les repas « rapides » doivent rester chauds et pris à table pour être acceptés comme de vrais repas : proposer des plats chauds en 15 minutes (omelette, poêlées, soupes-repas) plutôt que des sandwichs ou des salades froides. On peut alléger les éléments périphériques sans heurter la représentation (dessert remplacé par un fruit, pain non obligatoire) ; on encourage le repas à table même quand il est court.

5. Les réponses dépendent de la formulation de la question ; le seuil de 75 % est conventionnel ; l'échantillon n'est peut-être pas représentatif (habitants qui fréquentent la maison de quartier) ; la mise en cause ne dit pas pourquoi un élément est central.

Partie 3 – Influence sociale, attitudes et stigmatisation

Objectifs – Objectifs de la partie

- Présenter les grandes expériences sur l'influence sociale : normalisation (Sherif), conformisme (Asch), influence minoritaire (Moscovici), décision de groupe (Lewin).
- Expliquer la dissonance cognitive (Festinger) et la théorie de l'engagement (Kiesler ; Joule et Beauvois), et les utiliser de façon éthique.
- Distinguer stéréotype, préjugé, discrimination et stigmatisation ; prévenir la stigmatisation liée au poids.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Normalisation (Sherif, 1935) : face à une situation ambiguë, un groupe construit une norme commune. Conformisme (Asch, 1951) : un individu se range à l'avis faux d'une majorité unanime. Influence minoritaire (Moscovici, 1969) : une minorité cohérente et constante peut faire évoluer la majorité.
- Décision de groupe (Lewin, 1943) : une décision prise après discussion en groupe change davantage les comportements qu'une conférence. Les ménagères sont les « gardiennes du portail » (gatekeepers) de l'alimentation familiale.
- Dissonance cognitive (Festinger, 1957) : tension née de deux cognitions incompatibles ; on la réduit en changeant le comportement, la croyance, ou en ajoutant une justification.
- Engagement (Kiesler, 1971 ; Joule et Beauvois, 1998) : un acte libre, public, répété et coûteux engage la personne et rend plus probables des actes cohérents avec lui. Pied-dans-la-porte (Freedman et Fraser, 1966).
- Stéréotype (croyance), préjugé (jugement affectif), discrimination (acte) ; stigmate (Goffman, 1963) : attribut qui discrédite profondément une personne.

Exercice 3.13 – Les grandes expériences de l'influence sociale (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une fiche de révision pour vos camarades et vous voulez relier chaque expérience à une situation de terrain en nutrition.

Document 1 – Quatre situations de terrain

a) Dans un atelier, personne ne sait combien de sel mettre dans la soupe ; après quelques essais, tout le groupe adopte « une demi-cuillère ».

b) Dans une classe, tous les élèves disent que le plat de lentilles est « immangeable » ; Inès, qui l'aimait, dit qu'elle ne l'aime pas non plus.

c) Deux élèves végétariens défendent calmement et régulièrement le menu végétarien ; à la fin de l'année, plusieurs camarades le choisissent.

d) Après une discussion en petit groupe, chaque parent annonce ce qu'il va essayer à la maison ; deux semaines plus tard, beaucoup l'ont fait.

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque situation à une expérience (auteur, année, notion). (4 pts)
2. Pour l'expérience d'Asch, indiquez deux conditions qui diminuent le conformisme. (2 pts)
3. Indiquez les trois qualités du comportement d'une minorité qui la rendent influente. (2 pts)
4. Montrez l'intérêt de la situation c) pour un projet de santé publique. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.14 – L'expérience de Lewin (1943) et le travail en groupe (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice de stage vous demande pourquoi vous préférez organiser des ateliers en petits groupes plutôt que des conférences. Vous vous appuyez sur une expérience historique.

Document 1 – L'expérience de Kurt Lewin (États-Unis, 1943)

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain veut que les familles consomment davantage d'abats (cœur, rognons, ris), alors peu appréciés, pour économiser la viande destinée aux soldats. Kurt Lewin compare deux méthodes auprès de groupes de ménagères : trois groupes écoutent une conférence attractive sur les qualités nutritionnelles et économiques des abats, avec des recettes ; trois autres groupes discutent, guidés par un animateur, des obstacles et des solutions, puis chaque participante indique à main levée si elle compte en servir. Une enquête est faite quelques jours plus tard. Résultat : 3 % des ménagères des groupes « conférence » ont servi un abat jamais servi auparavant, contre 32 % des ménagères des groupes « discussion et décision ».

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le rapport entre les deux pourcentages et rédigez une phrase d'interprétation. (2 pts)
2. Expliquez la notion de « gardien du portail » (gatekeeper) et son intérêt pour choisir un public cible. (2 pts)
3. Identifiez trois facteurs qui expliquent la supériorité de la décision de groupe (participation, engagement public, norme de groupe). (3 pts)
4. Indiquez deux limites de cette expérience (époque, méthode). (2 pts)
5. Transposez la méthode à un atelier actuel sur la consommation de légumineuses : décrivez le déroulé en trois temps. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.15 – Légender la dissonance cognitive (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un stand de prévention dans un centre commercial, un homme vous dit : « Je sais que les boissons sucrées favorisent le diabète, mais j'en bois un litre par jour. De toute façon, mon grand-père en buvait et il a vécu jusqu'à 90 ans. »

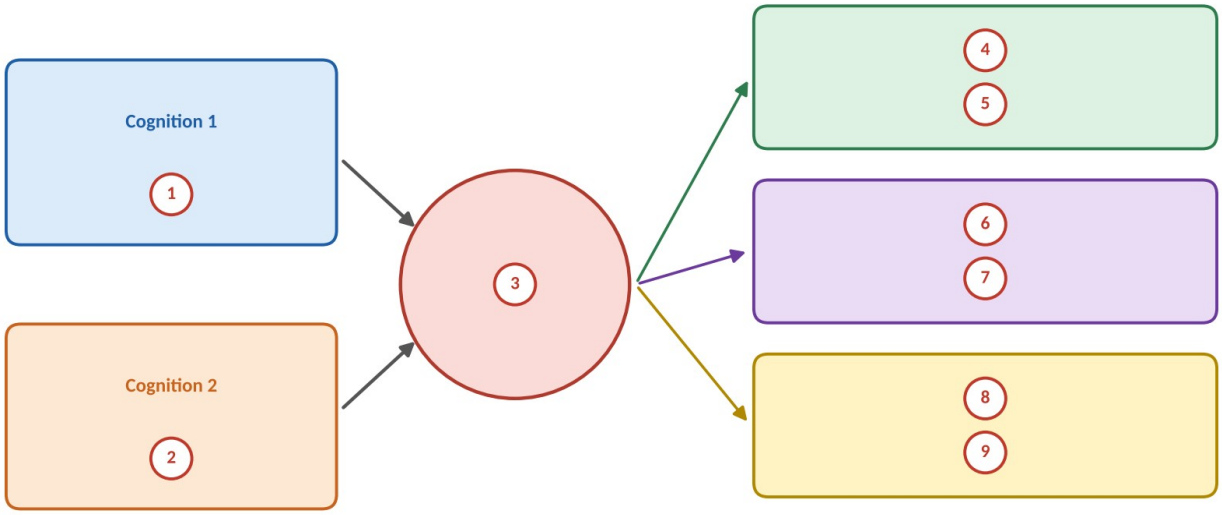


Figure 3.4 – Document 1 – La dissonance cognitive (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)
2. Identifiez la stratégie de réduction de la dissonance utilisée par cet homme. (1,5 pt)
3. Expliquez pourquoi un message qui fait peur (« vous allez devenir diabétique ») peut renforcer cette stratégie. (2 pts)
4. Proposez une réponse orale de professionnel qui aide l'homme à envisager un petit changement de comportement. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.16 – Engagement et pied-dans-la-porte (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de parents veut encourager les familles à préparer le goûter « fait maison » une fois par semaine. Un parent propose d'utiliser la technique du « pied-dans-la-porte ». Vous êtes chargé de vérifier que la démarche est efficace et éthique.

Document 1 – L'expérience de Freedman et Fraser (1966, États-Unis)

Des enquêteurs demandent à des propriétaires d'accepter l'installation, dans leur jardin, d'un grand panneau peu esthétique « Conduisez prudemment ». Dans le groupe témoin, environ 17 % acceptent (16,7 %). Dans un autre groupe, on avait demandé deux semaines plus tôt à chaque propriétaire de poser à sa fenêtre un petit autocollant de 8 cm « Soyez un conducteur prudent » ; presque tous avaient accepté. Dans ce groupe, environ 76 % acceptent ensuite le grand panneau.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le rapport entre les deux taux d'acceptation et l'écart en points ; interprétez. (2 pts)
2. Définissez l'engagement et citez quatre facteurs qui le renforcent. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi le sentiment de liberté est indispensable (citez l'expression de Joule et Beauvois). (2 pts)
4. Construisez une démarche d'engagement en deux étapes pour le goûter fait maison. (3 pts)
5. Indiquez la limite éthique de ces techniques et la façon de la respecter. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.17 – Légender stéréotype, préjugé, discrimination (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans un service de médecine du travail. Une salariée en situation d'obésité raconte qu'au restaurant d'entreprise ses collègues commentent son plateau, qu'elle a été écartée d'un poste d'accueil « pour l'image », et qu'elle ne va plus chez son médecin parce qu'il « ne parle que de son poids ».

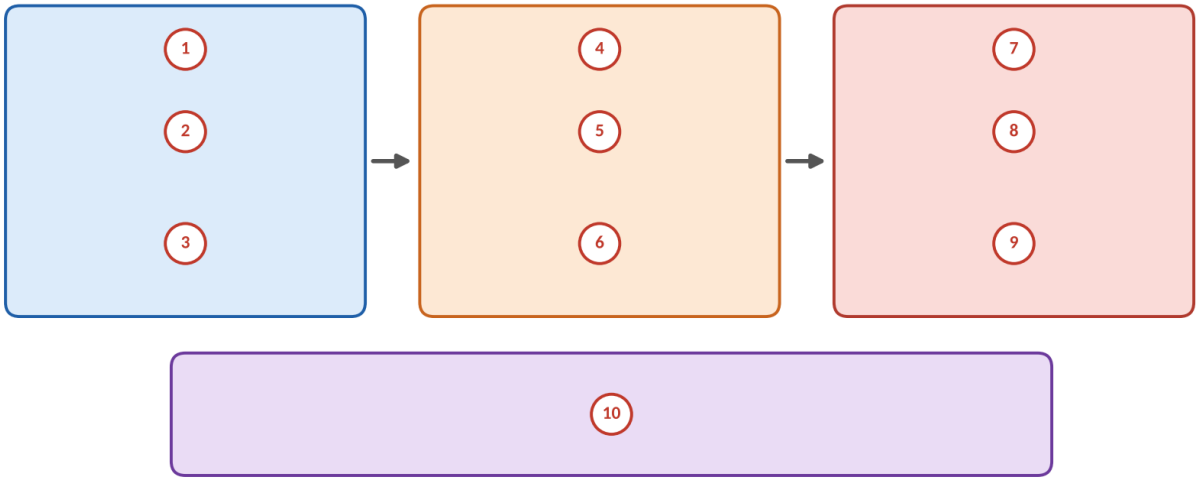


Figure 3.5 – Document 1 – Du stéréotype à la stigmatisation (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (5 pts)
2. Repérez dans la situation un exemple de préjugé, de discrimination et une conséquence de la stigmatisation sur la santé. (3 pts)
3. Indiquez si l'apparence physique est un critère de discrimination interdit en France et citez le texte. (2 pts)
4. Proposez deux règles de langage et de posture pour un professionnel de la nutrition. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.18 – Mesurer les attitudes envers les personnes obèses (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un institut de formation en soins infirmiers vous demande d'évaluer un module de 3 heures sur la stigmatisation liée au poids, destiné à 40 étudiants. Vous utilisez une échelle de 6 items, cotés de 1 (pas du tout d'accord) à 5 (tout à fait d'accord), avant et après le module.

Document 1 – L'échelle (construite pour l'exercice)

Item	Sens
1. Les personnes obèses manquent de volonté.	stigmatisant
2. Le poids dépend de nombreux facteurs que l'on ne contrôle pas.	non stigmatisant
3. Je serais gêné(e) de travailler avec une personne obèse.	stigmatisant
4. Les personnes obèses méritent le même respect que les autres.	non stigmatisant
5. Si elles le voulaient vraiment, les personnes obèses maigriraient.	stigmatisant
6. Les moqueries sur le poids font du mal.	non stigmatisant

Score total de 6 à 30, calculé après inversion des items non stigmatisants (score inversé = 6 − réponse) : plus le score est élevé, plus l'attitude est stigmatisante.

Document 2 – Résultats (données fictives)

Réponses de l'étudiante E12 avant le module : item 1 = 4 ; item 2 = 2 ; item 3 = 3 ; item 4 = 4 ; item 5 = 5 ; item 6 = 4.

Score moyen du groupe : 18,6 avant le module ; 14,2 après. Part des étudiants dont le score est d'au moins 18 : 24 sur 40 avant ; 11 sur 40 après.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi certains items sont inversés. (2 pts)
2. Calculez le score de l'étudiante E12. (3 pts)
3. Calculez la baisse du score moyen en points et en pourcentage, et l'évolution de la part des scores d'au moins 18. (4 pts)
4. Interprétez ces résultats avec prudence : pourquoi ne peut-on pas conclure que les comportements des étudiants ont changé ? (4 pts)
5. Proposez une amélioration du protocole d'évaluation. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 3.13

1. a) Sherif (1935), normalisation : dans une situation ambiguë, le groupe construit une norme commune. b) Asch (1951), conformisme : un individu se range à l'avis d'une majorité unanime, même contre son propre jugement. c) Moscovici (1969), influence minoritaire : une minorité consistante fait évoluer la majorité. d) Lewin (1943), décision de groupe : la discussion suivie d'un engagement public change les comportements.
2. La présence d'un seul allié qui donne la bonne réponse ; une réponse écrite et anonyme plutôt qu'orale et publique ; un groupe plus petit ou non unanime ; une tâche moins ambiguë ou une forte confiance en soi.
3. La consistance (ou constance) dans le temps, la cohérence entre les membres de la minorité, et une attitude non rigide qui ne paraît pas dogmatique.
4. Un petit groupe de jeunes convaincus (ou de professionnels) peut faire évoluer une norme du groupe, à condition de garder un discours cohérent dans la durée. C'est le principe de la pair-éducation et des personnes relais : on n'a pas besoin de convaincre tout le monde au départ.

Corrigé – Exercice 3.14

1. 32 / 3 = 10,7. La décision de groupe a été près de 11 fois plus efficace que la conférence pour faire servir un abat nouveau (écart de 29 points).
2. Pour Lewin, les aliments passent par des « canaux » (achat, préparation, service) contrôlés par des personnes qui décident de ce qui entre dans la maison ; en 1943, les ménagères étaient ces gardiennes du portail. En santé publique, il est souvent plus efficace de cibler ces personnes clés (parents, cuisiniers de collectivité, responsables des achats) que l'ensemble des mangeurs.
3. Participation active : les ménagères ont formulé elles-mêmes les obstacles et les solutions. Engagement public : la décision annoncée à main levée devant le groupe engage. Norme de groupe : voir que d'autres décident aussi de servir des abats rend le comportement normal et partagé.
4. Contexte de guerre très particulier (patriotisme, rationnement) ; petits effectifs ; mesure déclarative quelques jours après, sans suivi à long terme ; rôle de la personnalité des animateurs ; public uniquement féminin, à une époque où les rôles de genre étaient très marqués.
5. Temps 1 (15 min) : en petit groupe, les participants listent ce qui les freine pour cuisiner des légumineuses (temps de cuisson, digestion, goût des enfants). Temps 2 (40 min) : dégustation et recherche collective de solutions (conserves, lentilles corail sans trempage, recettes appréciées des enfants), préparation d'une recette. Temps 3 (10 min) : chacun choisit librement ce qu'il essaiera dans la semaine et peut l'annoncer au groupe ; un message de rappel ou un point à la séance suivante.

Corrigé – Exercice 3.15

1. Légendes : 1 « Les boissons sucrées favorisent le diabète » ; 2 « J'en bois un litre par jour » ; 3 Dissonance : tension désagréable ; 4 Changer le comportement ; 5 réduire les boissons sucrées ; 6 Changer la croyance ; 7 « ce n'est pas si grave » ; 8 Ajouter une cognition ; 9 « je fais du sport, ça compense ».
2. Il ajoute une cognition consonante (« mon grand-père en buvait et il a vécu jusqu'à 90 ans ») qui minimise le risque : c'est une rationalisation, proche de la stratégie « changer la croyance ».
3. Un message qui fait peur augmente la tension ; si la personne ne se sent pas capable de changer, la façon la plus simple de réduire la dissonance est de rejeter le message (déni, minimisation, évitement de l'information). La peur n'est efficace que si l'on propose en même temps une solution facile, que la personne se sent capable d'appliquer.
4. Exemple : « Vous savez déjà beaucoup de choses sur les boissons sucrées. Si vous deviez changer une petite chose, qu'est-ce qui vous paraîtrait le plus facile : remplacer un verre par de l'eau pétillante, choisir une bouteille plus petite ? » La réponse respecte sa liberté, valorise ses connaissances et propose un

petit pas.

Corrigé – Exercice 3.16

1. Rapport : 76 / 16,7 = 4,55. Écart : 76 − 16,7 = 59,3 points. Les propriétaires qui avaient d'abord accepté un petit acte ont été environ 4,6 fois plus nombreux à accepter la demande coûteuse.

2. L'engagement est le lien qui unit une personne à ses actes (Kiesler, 1971) : plus on est engagé dans un acte, plus on tend à agir et à penser de façon cohérente avec lui. Facteurs : sentiment de liberté, caractère public de l'acte, répétition, coût de l'acte, irrévocabilité, explication par des causes internes (« vous êtes quelqu'un qui… »).

3. Joule et Beauvois parlent de « soumission librement consentie » (1998) : l'engagement ne fonctionne que si la personne a le sentiment d'avoir choisi ; sous la contrainte ou contre une récompense importante, elle attribue son acte à la pression extérieure et ne s'engage pas.

4. Étape 1 (acte peu coûteux) : à la sortie de l'école, proposer aux parents de goûter un goûter fait maison et de choisir une recette préférée parmi trois (vote libre). Étape 2 (acte plus coûteux) : proposer à ceux qui ont voté de s'inscrire, s'ils le souhaitent, au « défi goûter maison du mercredi » pendant un mois, avec leur prénom sur le tableau des familles participantes et un message de rappel. On rappelle à chaque étape qu'ils sont libres de refuser.

5. Ces techniques peuvent devenir manipulatrices si elles servent un but que la personne ne partagerait pas ou cachent l'objectif réel. On les respecte en annonçant clairement le but, en laissant une liberté réelle de refuser, en ne visant que des comportements favorables à la personne et en évitant toute pression ou toute stigmatisation des familles qui ne participent pas.

Corrigé – Exercice 3.17

1. Légendes : 1 Stéréotype ; 2 composante cognitive : une croyance ; 3 « Les personnes en surpoids manquent de volonté » ; 4 Préjugé ; 5 composante affective : un jugement ; 6 mépris, rejet, moquerie ; 7 Discrimination ; 8 composante comportementale : un acte ; 9 refus d'embauche, mise à l'écart ; 10 Stigmatisation : la personne est réduite à une caractéristique dévalorisée ; elle peut intérioriser le stigmate (Goffman, 1963).

2. Préjugé : les commentaires des collègues sur son plateau (jugement moral). Discrimination : l'éviction d'un poste d'accueil « pour l'image ». Conséquence sur la santé : elle renonce aux soins chez son médecin ; la stigmatisation entraîne aussi stress, honte, isolement et parfois alimentation émotionnelle.

3. Oui. Le code du travail (article L1132-1) et le code pénal (article 225-1) interdisent les discriminations fondées notamment sur l'apparence physique et l'état de santé. La salariée peut saisir le Défenseur des droits.

4. Parler de « personne en situation d'obésité » ou « personne qui vit avec une obésité » et non « d'obèse » ; ne pas parler du poids si la personne ne le souhaite pas et demander la permission (« Accepteriez-vous qu'on parle de… ? ») ; prévoir du matériel adapté (sièges, brassard de tension) ; centrer le discours sur les comportements favorables à la santé et non sur le chiffre de la balance.

Corrigé – Exercice 3.18

1. Pour que toutes les réponses aillent dans le même sens (un score élevé signifie toujours une attitude plus stigmatisante) et pour limiter le biais d'acquiescement : une personne qui répond « d'accord » à tout obtiendrait sinon un score artificiel.

2. Items stigmatisants (sans inversion) : 4 + 3 + 5 = 12. Items non stigmatisants inversés : item 2 : 6 − 2 = 4 ; item 4 : 6 − 4 = 2 ; item 6 : 6 − 4 = 2 ; total 8. Score de E12 = 12 + 8 = 20 sur 30 (score moyen par item : 20 / 6 = 3,33).

3. Baisse du score moyen : 18,6 − 14,2 = 4,4 points, soit 4,4 / 18,6 × 100 = 23,7 % de baisse. Part des scores

d'au moins 18 : avant 24 / 40 × 100 = 60,0 % ; après 11 / 40 × 100 = 27,5 % ; baisse de 32,5 points.

4. Les attitudes déclarées ont diminué juste après le module, mais : mesure immédiate (effet possiblement passager) ; désirabilité sociale (les étudiants savent ce que l'on attend d'eux après un module sur ce thème) ; pas de groupe témoin ; échelle non validée ; une attitude déclarée ne prédit pas toujours un comportement en situation de soin. On peut seulement dire que le module semble avoir fait évoluer les attitudes déclarées à court terme.

5. Ajouter une mesure à distance (3 mois) ; utiliser une échelle validée (par exemple une version française d'une échelle d'attitudes anti-gros validée) ; comparer avec un groupe témoin qui suit le module plus tard ; observer des comportements en stage (grille d'observation par les tuteurs) ; garantir l'anonymat avec un code pour apparier les questionnaires avant et après.

Partie 4 – Compétences psychosociales, émotions, image du corps et estime de soi

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer et classer les 9 compétences psychosociales générales (Santé publique France, 2022) ; concevoir une séance qui les développe.
- Mesurer et interpréter l'estime de soi et l'insatisfaction corporelle avec des outils simples.
- Distinguer faim physiologique et faim émotionnelle ; accompagner sans culpabiliser.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Compétences psychosociales (CPS) : ensemble cohérent et interrelié de capacités psychologiques (cognitives, émotionnelles et sociales) qui permettent d'augmenter l'autonomie et le pouvoir d'agir, de maintenir un état de bien-être et de favoriser des interactions constructives (Santé publique France, 2022). L'OMS en avait listé 10 en 1993.
- Stratégie nationale multisectorielle de développement des CPS chez les enfants et les jeunes 2022-2037 (instruction interministérielle du 19 août 2022).
- Interventions efficaces : critères SAFE (Durlak et ses collègues, 2011) : séquencées, actives, focalisées, explicites ; plusieurs séances, animateurs formés.
- Estime de soi : valeur qu'une personne s'accorde ; échelle de Rosenberg (1965), 10 items.
- Image corporelle : représentation mentale de son corps et sentiments qui y sont liés ; l'insatisfaction se mesure par exemple avec les silhouettes de Stunkard (1983).
- Faim émotionnelle : envie de manger déclenchée par une émotion (stress, ennui, tristesse), brutale, ciblée sur certains aliments, qui ne cesse pas avec la satiété.

Exercice 3.19 – Légender les compétences psychosociales (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une coordinatrice d'un projet éducatif de territoire vous demande de montrer que des ateliers de cuisine avec des enfants de 9 à 11 ans développent des CPS.

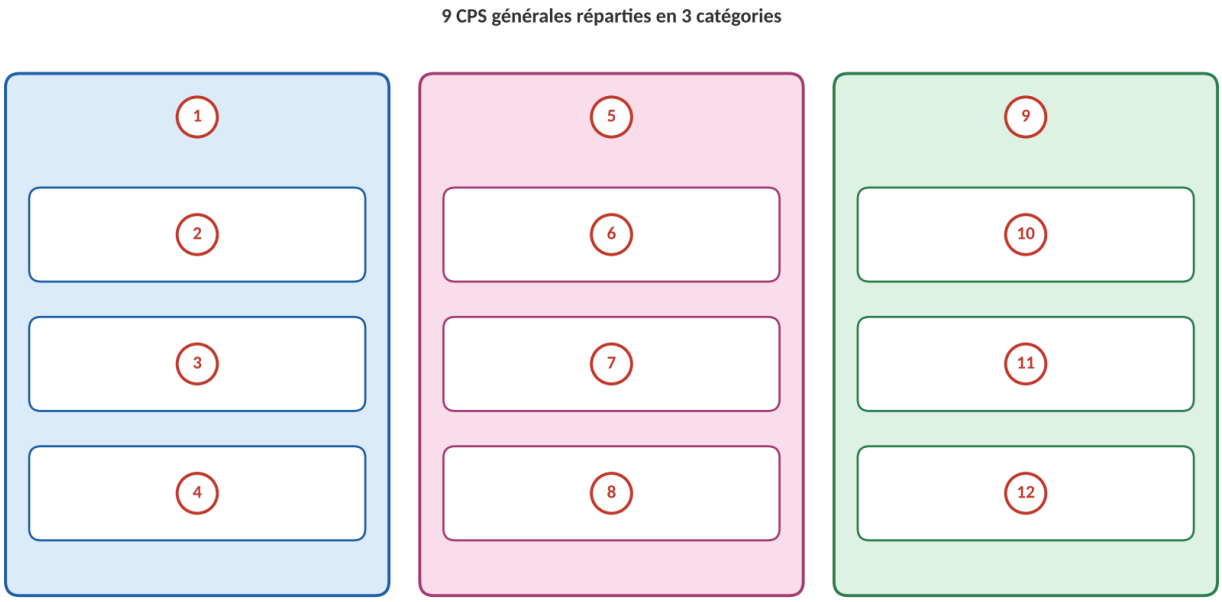


Figure 3.6 – Document 1 – Les compétences psychosociales générales (schéma à légender)

Document 2 – Moments de l'atelier cuisine

a) Les enfants se répartissent les tâches et règlent un désaccord sur le choix de la recette.

b) Un enfant qui n'aime pas l'odeur du poisson apprend à dire « je n'aime pas » sans crier « c'est dégueulasse ».

c) Les enfants comparent deux goûters et choisissent celui qu'ils prépareront, avec des arguments.

d) Avant de goûter, chaque enfant dit comment il se sent (curieux, inquiet, content) avec des cartes émotions.

e) Un enfant attend son tour pour utiliser le fouet au lieu de l'arracher.

f) Les enfants écoutent l'avis des autres sur la dégustation et donnent le leur avec respect.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (6 pts)
2. Associez chaque moment du document 2 à une CPS générale. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi un atelier unique ne suffit pas à développer des CPS (critères d'efficacité). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.20 – Construire une séance CPS « explicite » (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – conception · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une maison des jeunes, vous animez un cycle de 6 séances « Mon assiette, mes choix » avec 12 adolescents de 13 à 15 ans. La séance 3 doit travailler la CPS « prendre des décisions constructives » à partir des choix d'achat en sortie de collège (boulangerie, épicerie, restauration rapide).

À vous de jouer – Questions

1. Présentez les critères SAFE et dites ce que chacun implique pour votre cycle. (4 pts)
2. Rédigez l'objectif de la séance 3 en termes de capacités observables. (2 pts)
3. Présentez le déroulé de 90 minutes en quatre temps, avec une technique active pour chaque temps. (4 pts)
4. Proposez un moyen d'évaluer la séance. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.21 – Estime de soi : coter une échelle (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un programme d'éducation thérapeutique pour des adultes vivant avec une obésité, la psychologue utilise une échelle d'estime de soi en début de programme. Elle vous demande de calculer le score d'une participante et de réfléchir à l'usage de ce résultat.

Document 1 – Échelle d'estime de soi en 10 items, inspirée de Rosenberg (1965)

Réponses de 1 (tout à fait en désaccord) à 4 (tout à fait d'accord). Les items 3, 5, 8, 9 et 10 sont formulés négativement (par exemple : « J'ai parfois l'impression de n'être bon(ne) à rien ») et doivent être inversés : score inversé = 5 − réponse. Score total de 10 à 40 ; plus il est élevé, plus l'estime de soi est haute.

Item	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Réponse de Mme V.	3	3	3	2	3	2	2	4	2	3

À vous de jouer – Questions

1. Définissez l'estime de soi. (1 pt)
2. Calculez le score total de Mme V. et son score moyen par item. (4 pts)
3. Indiquez sur quels items elle s'évalue le plus négativement. (2 pts)
4. Expliquez le lien possible entre stigmatisation du poids, estime de soi et comportements alimentaires. (3 pts)
5. Indiquez deux précautions dans l'usage de ce score par un diététicien. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.22 – Insatisfaction corporelle et silhouettes (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une infirmière scolaire de lycée a utilisé une échelle de 9 silhouettes (de 1, très mince, à 9, très corpulente), inspirée de Stunkard (1983), dans une classe de 30 élèves de seconde. Chaque élève a indiqué la silhouette qui lui ressemble (silhouette perçue) et celle qu'il voudrait avoir (silhouette désirée). Elle vous demande de traiter les résultats.

Document 1 – Écart entre silhouette perçue et silhouette désirée (perçue − désirée), données fictives

Écart	− 2	− 1	0	+ 1	+ 2	+ 3
Nombre d'élèves	2	4	9	8	5	2

Un écart positif signifie que l'élève voudrait être plus mince ; un écart négatif, plus corpulent.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part des élèves satisfaits, de ceux qui veulent être plus minces et de ceux qui veulent être plus corpulents. (3 pts)
2. Calculez l'écart moyen de la classe. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi le désir d'être plus corpulent concerne souvent des garçons, et le désir de minceur souvent des filles (normes corporelles de genre, réseaux sociaux). (3 pts)
4. Indiquez les risques liés à une forte insatisfaction corporelle à l'adolescence. (2 pts)
5. Proposez deux actions de prévention qui ne parlent pas de poids. (2 pts)
6. Indiquez deux précautions éthiques pour ce type de recueil en classe. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.23 – Faim physiologique et faim émotionnelle (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un service de santé universitaire, une étudiante de 20 ans vous explique : « Le soir, après les cours, je rentre seule dans mon studio. Je n'ai pas vraiment faim, mais je mange un paquet de biscuits devant mon téléphone, et après je m'en veux. En période d'examens, c'est pire. »

À vous de jouer – Questions

1. Présentez quatre différences entre faim physiologique et faim émotionnelle. (4 pts)
2. Identifiez dans le témoignage les déclencheurs émotionnels et le cycle « émotion – prise alimentaire – culpabilité ». (2 pts)
3. Indiquez les CPS émotionnelles à développer et proposez deux pistes concrètes, sans interdits alimentaires. (3 pts)
4. Indiquez dans quel cas il faut orienter l'étudiante vers un autre professionnel. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.24 – Un programme CPS et nutrition au collège (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement (CESCE) d'un collège de 520 élèves vous confie la conception d'un programme pour les élèves de 5e. Le questionnaire réalisé en juin auprès des 132 élèves de 6e (futurs 5e) donne les résultats suivants (données fictives).

Document 1 – Résultats du questionnaire (n = 132)

Affirmation	Élèves « d'accord » ou « tout à fait d'accord »
Je mange parfois parce que je m'ennuie ou que je suis énervé(e).	59
J'ose dire non quand mes amis me proposent quelque chose que je ne veux pas manger ou boire.	71
Je me moque parfois du physique ou de ce que mangent les autres.	38
On s'est déjà moqué de mon physique ou de ce que je mange.	47
Je sais trouver quelqu'un à qui parler quand ça ne va pas.	84
J'aime mon corps tel qu'il est.	69

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages et identifiez les trois résultats les plus préoccupants. (4 pts)
2. Reliez chaque résultat préoccupant à une ou plusieurs CPS. (3 pts)
3. Proposez un programme de 5 séances de 55 minutes (titre, CPS travaillée, technique), conforme aux critères SAFE. (5 pts)
4. Proposez les partenaires et le rôle de chacun. (2 pts)
5. Proposez deux indicateurs d'évaluation. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 3.19

1. Légendes : 1 Compétences cognitives ; 2 Avoir conscience de soi ; 3 Capacité de maîtrise de soi ; 4 Prendre des décisions constructives ; 5 Compétences émotionnelles ; 6 Avoir conscience de ses émotions et de son stress ; 7 Réguler ses émotions ; 8 Gérer son stress ; 9 Compétences sociales ; 10 Communiquer de façon constructive ; 11 Développer des relations constructives ; 12 Résoudre des difficultés.
2. a) résoudre des difficultés (et communiquer de façon constructive) ; b) réguler ses émotions ; c) prendre des décisions constructives ; d) avoir conscience de ses émotions et de son stress ; e) capacité de maîtrise de soi ; f) communiquer de façon constructive (et développer des relations constructives).
3. Les CPS se développent par une pratique répétée et progressive. Selon les critères SAFE (Durlak et ses collègues, 2011), les programmes efficaces sont séquencés (séances qui s'enchaînent), actifs (mises en situation), focalisés (temps suffisant consacré aux CPS) et explicites (les CPS visées sont nommées). Un atelier unique peut sensibiliser mais ne transforme pas durablement les compétences ; il faut plusieurs séances, des adultes formés et un lien avec la vie quotidienne de l'enfant (classe, famille).

Corrigé – Exercice 3.20

1. Séquencé : les 6 séances suivent une progression (se connaître, émotions, décider, résister à la pression, communiquer, projet). Actif : chaque séance comporte une mise en situation (jeu de rôle, défi, enquête). Focalisé : au moins 40 minutes par séance consacrées à la compétence. Explicite : la CPS est annoncée au début (« aujourd'hui, on apprend à prendre une décision ») et reprise à la fin.
2. À la fin de la séance, chaque adolescent sera capable de citer les étapes d'une décision (identifier les choix, peser les avantages et inconvénients, décider, évaluer) et de les appliquer à un choix d'achat de goûter avec un budget de 3 €.
3. Temps 1 (15 min) : photolangage : chacun choisit une photo de ce qu'il achète en sortant du collège et dit pourquoi. Temps 2 (25 min) : enquête en binômes sur des emballages et des prix ; tableau « avantages, inconvénients » pour trois achats. Temps 3 (35 min) : jeu de rôle « devant la boulangerie avec les copains » : un jeune doit choisir en tenant compte de son budget, de sa faim et du groupe ; débriefing des étapes de la décision. Temps 4 (15 min) : chacun écrit une décision qu'il veut tester cette semaine (engagement libre) ; tour de parole sur ce qu'il a appris.
4. Questionnaire court en fin de séance : « Je sais citer les étapes d'une décision » (oui, un peu, non) ; observation du jeu de rôle avec une grille (le jeune a-t-il nommé au moins deux options et un critère ?) ; à la séance suivante, retour sur la décision testée.

Corrigé – Exercice 3.21

1. L'estime de soi est la valeur, positive ou négative, qu'une personne s'accorde globalement ; elle repose sur le sentiment d'être aimable, compétent et digne de respect.
2. Items positifs (1, 2, 4, 6, 7) : 3 + 3 + 2 + 2 + 2 = 12. Items négatifs inversés : item 3 : 5 − 3 = 2 ; item 5 : 5 − 3 = 2 ; item 8 : 5 − 4 = 1 ; item 9 : 5 − 2 = 3 ; item 10 : 5 − 3 = 2 ; total 10. Score total = 12 + 10 = 22 sur 40 ; score moyen par item = 22 / 10 = 2,2 sur 4, sous le milieu de l'échelle (2,5).
3. L'item 8 (score inversé de 1, le plus bas possible), puis les items 3, 4, 5, 6, 7 et 10 (score de 2).
4. La stigmatisation (moqueries, remarques, discriminations) abaisse l'estime de soi ; une faible estime de soi s'accompagne souvent de honte du corps, d'évitement des activités sociales et physiques, de régimes répétés et d'alimentation émotionnelle, qui peuvent favoriser la prise de poids. C'est un cercle vicieux que les programmes doivent briser en évitant tout discours culpabilisant.
5. Ce score ne sert pas à poser un diagnostic : il est interprété par la psychologue, avec la personne ; il reste confidentiel (donnée personnelle sensible) ; le diététicien en tient compte dans sa posture (valoriser les réussites, objectifs atteignables) et oriente vers la psychologue si la personne exprime une souffrance importante.

Corrigé – Exercice 3.22

1. Satisfaits (écart 0) : 9 / 30 × 100 = 30,0 %. Veulent être plus minces (écart positif) : (8 + 5 + 2) / 30 × 100 = 15 / 30 × 100 = 50,0 %. Veulent être plus corpulents (écart négatif) : (2 + 4) / 30 × 100 = 6 / 30 × 100 = 20,0 %. Au total, 70,0 % des élèves sont insatisfaits de leur silhouette.

2. Somme des écarts : (− 2 × 2) + (− 1 × 4) + (0 × 9) + (1 × 8) + (2 × 5) + (3 × 2) = − 4 − 4 + 0 + 8 + 10 + 6 = 16. Écart moyen = 16 / 30 = + 0,53 : en moyenne, la classe voudrait être un peu plus mince.

3. Les normes corporelles sont différentes selon le genre : idéal de minceur pour les filles, idéal de muscles et de force pour les garçons. Ces normes sont transmises par la famille, les pairs, la publicité et surtout les réseaux sociaux (photos retouchées, filtres, contenus « fitness »), qui renforcent la comparaison sociale à l'adolescence.

4. Régimes restrictifs sans avis médical, troubles du comportement alimentaire, consommation de compléments « pour prendre du muscle », baisse de l'estime de soi, anxiété, évitement du sport et des situations sociales, moqueries.

5. Ateliers d'éducation aux médias (repérer les retouches et les filtres, décrypter les contenus « fitness ») ; séances sur l'estime de soi et la gratitude envers son corps (ce que mon corps me permet de faire) ; activités physiques centrées sur le plaisir et non sur l'apparence.

6. Accord des élèves et information des parents ; anonymat (pas de nom, réponses glissées dans une urne) ; pas de pesée en classe ; présentation des résultats seulement à l'échelle de la classe ; possibilité de parler à l'infirmière après la séance.

Corrigé – Exercice 3.23

1. Faim physiologique : apparaît progressivement ; se ressent dans le corps (creux à l'estomac, baisse d'énergie) ; peut être satisfaite par des aliments variés ; s'arrête avec la satiété ; ne laisse pas de culpabilité. Faim émotionnelle : apparaît brutalement ; vient d'une émotion (ennui, solitude, stress) ; vise des aliments précis, souvent sucrés ou gras ; continue malgré la satiété ; suivie de culpabilité.

2. Déclencheurs : solitude du retour au studio, fatigue de la journée, stress des examens, écran. Cycle : émotion désagréable, biscuits mangés pour se soulager, soulagement court, puis culpabilité (« je m'en veux »), qui est elle-même une émotion désagréable et relance le cycle.

3. Avoir conscience de ses émotions et de son stress, réguler ses émotions, gérer son stress. Pistes : tenir quelques jours un carnet « ce que je ressens avant de manger » pour repérer les moments ; préparer une autre réponse aux émotions (appeler quelqu'un, sortir marcher dix minutes, une activité agréable) ; prévoir un vrai dîner ou une collation choisie, assise, sans écran, pour éviter d'arriver au studio affamée ; ne pas s'interdire les biscuits, ce qui renforcerait l'envie.

4. Si les prises alimentaires sont très importantes, avec perte de contrôle, fréquentes ou suivies de vomissements, ou si la souffrance est forte : orientation vers le médecin du service de santé universitaire et une psychologue (suspicion de trouble du comportement alimentaire).

Corrigé – Exercice 3.24

1. Mange par ennui ou énervement : 59 / 132 × 100 = 44,7 %. Ose dire non : 71 / 132 × 100 = 53,8 % (donc 46,2 % n'osent pas toujours). Se moque des autres : 38 / 132 × 100 = 28,8 %. A subi des moqueries : 47 / 132 × 100 = 35,6 %. Sait à qui parler : 84 / 132 × 100 = 63,6 %. Aime son corps : 69 / 132 × 100 = 52,3 %. Résultats les plus préoccupants : près d'un élève sur deux mange sous le coup d'une émotion (44,7 %) ; plus d'un sur trois a subi des moqueries (35,6 %) ; près d'un sur deux n'aime pas son corps (47,7 %, soit 100 − 52,3).

2. Manger par émotion : avoir conscience de ses émotions, réguler ses émotions, gérer son stress. Moqueries : communiquer de façon constructive, développer des relations constructives (empathie), résoudre des difficultés. Rapport au corps : avoir conscience de soi (estime de soi). Difficulté à dire non : capacité de

maîtrise de soi, communiquer de façon constructive (affirmation de soi).

3. Exemple. Séance 1 « Qui suis-je ? » : conscience de soi, portrait chinois et règles du groupe. Séance 2 « La météo de mes émotions » : conscience de ses émotions, cartes émotions et lien avec l'envie de manger. Séance 3 « Que faire quand ça déborde ? » : réguler ses émotions et gérer son stress, techniques de respiration et liste personnelle de « bonnes idées ». Séance 4 « Les mots qui blessent » : relations constructives et empathie, jeu de rôle sur une moquerie à la cantine. Séance 5 « Oser dire non » : communiquer de façon constructive, jeu de rôle d'affirmation de soi, bilan du cycle. Chaque séance annonce la CPS (explicite), comporte une mise en situation (actif), s'appuie sur la précédente (séquencé) et consacre la majeure partie du temps à la compétence (focalisé).

4. Infirmière scolaire (coordination, repérage, écoute individuelle) ; professeurs principaux et professeur d'éducation physique (continuité en classe) ; conseillère principale d'éducation (lutte contre le harcèlement) ; psychologue de l'éducation nationale (élèves en souffrance) ; structure de promotion de la santé (formation des animateurs) ; parents (information, réunion).

5. Évolution, entre juin et la fin de l'année de 5e, de la part des élèves qui ont subi des moqueries et de la part de ceux qui osent dire non, avec le même questionnaire anonyme ; nombre de séances réalisées et taux de présence ; satisfaction des élèves.

Partie 5 – Les modèles du changement de comportement

Objectifs – Objectifs de la partie

- Présenter et légender les stades du changement (Prochaska et DiClemente), la théorie du comportement planifié (Ajzen), le modèle des croyances relatives à la santé (Rosenstock) et le modèle COM-B (Michie).
- Expliquer le sentiment d'efficacité personnelle et ses quatre sources (Bandura).
- Utiliser un modèle pour diagnostiquer les freins d'un public et choisir des actions adaptées.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Modèle transthéorique (Prochaska et DiClemente, 1983) : précontemplation, contemplation, préparation, action, maintien ; la rechute fait partie du processus.
- Théorie du comportement planifié (Ajzen, 1991) : l'intention dépend de l'attitude, de la norme subjective et du contrôle comportemental perçu ; l'intention prédit le comportement.
- Modèle des croyances relatives à la santé (Rosenstock, 1974 ; Becker, 1974) : vulnérabilité perçue, gravité perçue, bénéfices perçus, obstacles perçus, incitations à l'action, efficacité personnelle (ajoutée en 1988).
- Sentiment d'efficacité personnelle (Bandura, 1977) : croyance en sa capacité à réaliser une action ; quatre sources : expériences de maîtrise, expériences vicariantes, persuasion verbale, états physiologiques et émotionnels.
- COM-B (Michie, van Stralen et West, 2011) : un comportement apparaît si la personne en a la capacité, l'opportunité et la motivation ; la roue du changement de comportement propose 9 fonctions d'intervention.

Exercice 3.25 – Légender les stades du changement (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une association de patients diabétiques, vous rencontrez six adhérents qui parlent de leur activité physique et de leur consommation de boissons sucrées.

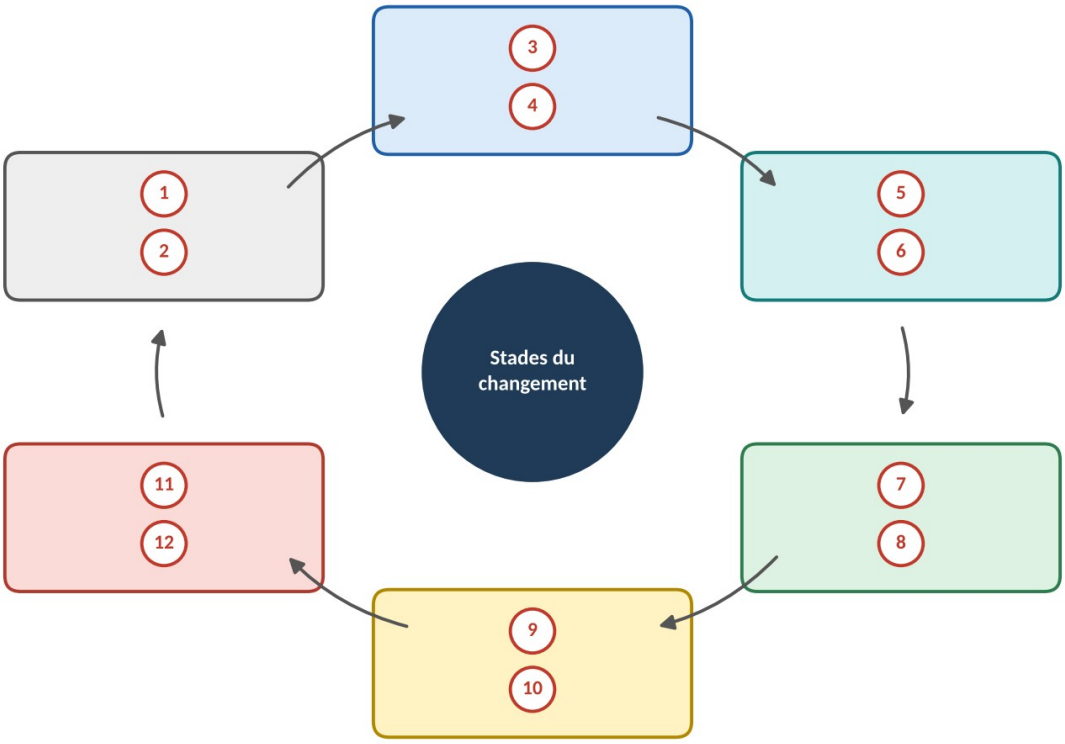


Figure 3.7 – Document 1 – Les stades du changement (schéma à légender)

Document 2 – Ce que disent les adhérents

a) « Ça fait un an que je ne bois plus de soda, j'ai même perdu l'envie. »

b) « Les boissons sucrées, ça ne me concerne pas, je ne suis pas gros. »

c) « J'ai acheté des baskets, je commence la marche lundi avec ma voisine. »

d) « Je sais que je devrais marcher, mais j'ai mal aux genoux et je n'ai pas le temps. »

e) « Depuis deux mois, je remplace le soda par de l'eau pétillante. »

f) « J'avais arrêté le soda pendant six mois, et cet été j'ai recommencé. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (6 pts)
2. Placez chaque adhérent dans un stade. (3 pts)
3. Indiquez l'intervention la plus adaptée pour les adhérents b), d) et f). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.26 – Légender la théorie du comportement planifié (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un questionnaire pour comprendre pourquoi les salariés d'une entreprise ne prennent pas de pause déjeuner.

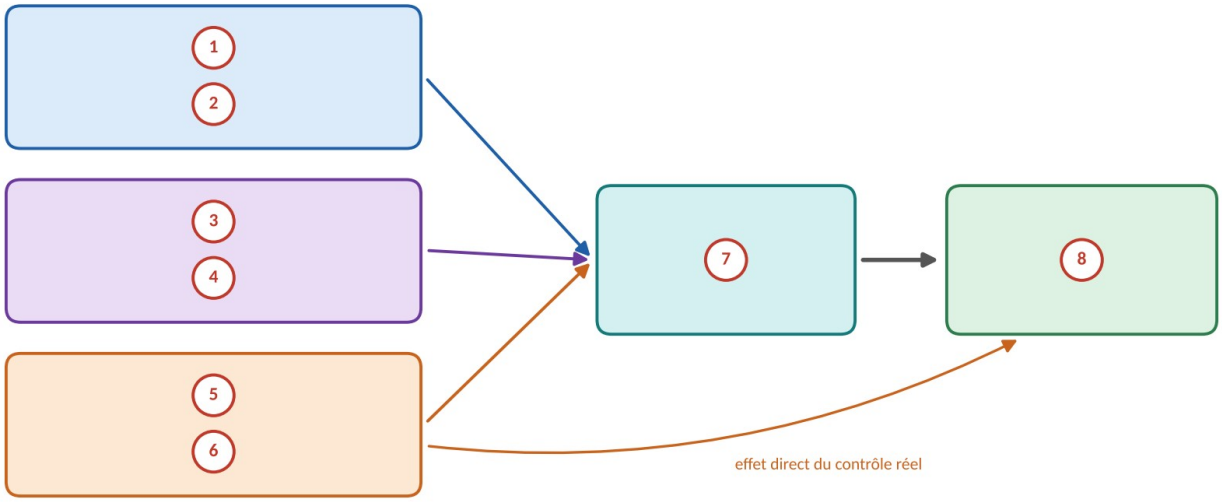


Figure 3.8 – Document 1 – La théorie du comportement planifié (schéma à légender)

Document 2 – Items proposés pour le questionnaire

a) « Prendre une vraie pause déjeuner me rendrait plus efficace l'après-midi. »

b) « Mon responsable trouve normal qu'on mange devant son écran. »

c) « Avec ma charge de travail, je ne peux pas m'arrêter 30 minutes. »

d) « La semaine prochaine, je compte prendre une pause déjeuner d'au moins 30 minutes trois jours sur cinq. »

e) « La plupart de mes collègues mangent à leur bureau. »

f) « Manger à son bureau, c'est mauvais pour la digestion. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Classez chaque item dans une composante du modèle. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi le contrôle perçu a deux flèches dans le modèle. (1 pt)
4. Indiquez une limite de ce modèle pour expliquer les comportements alimentaires. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.27 – Le modèle des croyances relatives à la santé (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une caisse d'assurance maladie organise des journées de dépistage du diabète dans des pharmacies. La participation est faible chez les hommes de 45 à 65 ans. Vous avez réalisé des entretiens.

Document 1 – Extraits d'entretiens

a) « Le diabète, c'est pour les gens qui mangent beaucoup de sucre. Moi, je n'en mange pas. »

b) « Mon frère est diabétique, il a été amputé d'un orteil l'an dernier. »

c) « Si je savais tôt, je pourrais faire attention avant que ce soit grave. »

d) « La pharmacie n'est ouverte que quand je travaille, et je n'aime pas les piqûres. »

e) « C'est le pharmacien qui m'en a parlé quand je suis allé chercher mes médicaments. »

f) « Je ne saurais pas quoi faire si on me disait que je suis diabétique. »

À vous de jouer – Questions

1. Présentez les six composantes du modèle et ses auteurs. (3 pts)
2. Associez chaque extrait à une composante. (3 pts)
3. Proposez trois actions pour augmenter la participation, chacune liée à une composante. (3 pts)
4. Indiquez une limite de ce modèle. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.28 – Les quatre sources du sentiment d'efficacité personnelle (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un cycle d'ateliers « cuisiner avec peu » pour des personnes accompagnées par un centre communal d'action sociale. Beaucoup disent : « Je ne suis pas capable de cuisiner. »

Document 1 – Ce que vous avez prévu

a) Chaque participant réalise lui-même une recette très simple dès la première séance, puis des recettes un peu plus difficiles.

b) Une ancienne participante, qui « ne savait rien faire » il y a un an, montre comment elle prépare un plat de lentilles.

c) Vous dites à chacun ce qu'il a réussi : « Votre découpe est très régulière. »

d) Vous commencez par un café et une présentation détendue, et vous dédramatisez les ratés.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez le sentiment d'efficacité personnelle (auteur, année). (2 pts)
2. Associez chaque élément du document 1 à une source du sentiment d'efficacité personnelle. (4 pts)
3. Indiquez la source la plus puissante et justifiez. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi une ancienne participante est un meilleur modèle qu'un chef cuisinier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.29 – Légender COM-B et choisir des fonctions d'intervention (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les aides-soignantes de nuit ne proposent presque jamais la collation nocturne prévue pour les résidents dénutris. Vous êtes chargé d'en comprendre les raisons.

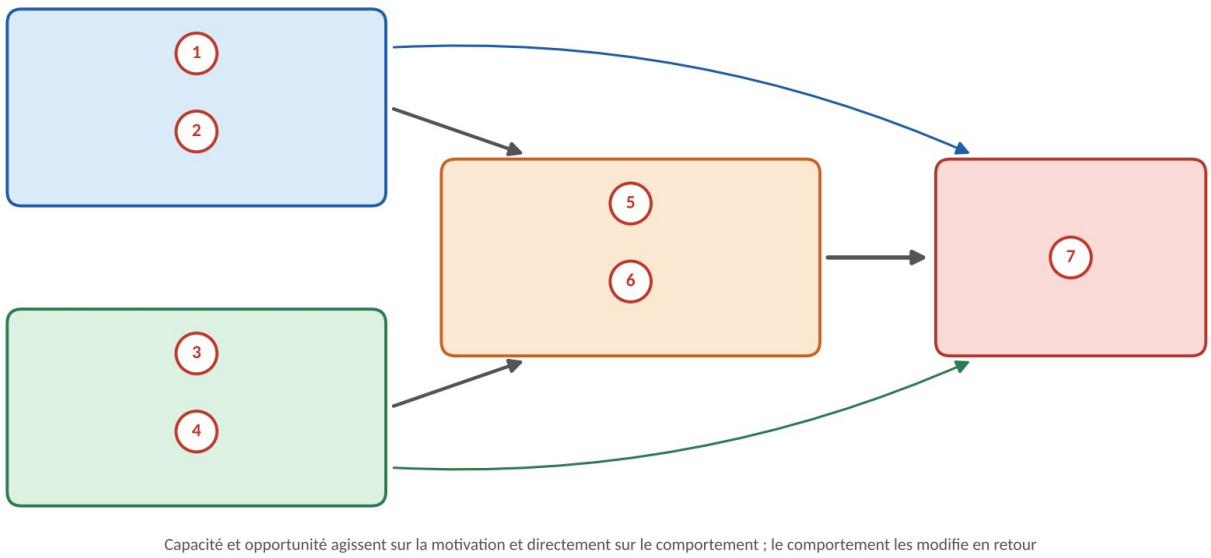


Figure 3.9 – Document 1 – Le modèle COM-B (schéma à légender)

Document 2 – Ce que disent les aides-soignantes de nuit

a) « Je ne savais pas que le jeûne nocturne devait être de moins de 12 heures. »

b) « Les collations sont dans la cuisine, fermée à clé la nuit. »

c) « Réveiller quelqu'un pour manger, ça me gêne, on nous a toujours dit de respecter le sommeil. »

d) « On est deux pour 80 résidents, on n'a pas le temps. »

e) « Mes collègues ne le font pas non plus. »

f) « Je pense que ça ne sert à rien, ils ne mangent pas. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)
2. Classez chaque extrait dans une composante de COM-B (capacité, opportunité physique ou sociale, motivation). (3 pts)
3. Citez les 9 fonctions d'intervention de la roue du changement de comportement. (2,5 pts)
4. Proposez trois actions, chacune associée à une fonction d'intervention et à une composante. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi une formation seule ne suffirait pas. (2 pts)

Ma réponse

.....

Exercice 3.30 – Évaluer un programme avec les stades du changement (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service de santé au travail a proposé pendant six mois un programme « Plus de fruits et légumes au travail » à 80 salariés volontaires d'une entreprise : panier de fruits deux fois par semaine, ateliers, défi d'équipe. Vous évaluez l'évolution des stades du changement pour le comportement « manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour ».

Document 1 – Répartition des 80 salariés par stade (données fictives)

Stade	Avant le programme	Après 6 mois
Précontemplation	28	18
Contemplation	22	20
Préparation	14	16
Action	10	15
Maintien	6	11

Suivi individuel : 34 salariés ont progressé d'au moins un stade, 38 sont restés au même stade, 8 ont reculé.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages par stade avant et après. (4 pts)
2. Calculez la part des salariés en action ou en maintien avant et après, et l'évolution en points. (2 pts)
3. Calculez la part des salariés qui ont progressé, stagné et reculé ; vérifiez le total. (2 pts)
4. Interprétez : pourquoi ce type d'évaluation est-il plus fin qu'un simple « mange ou ne mange pas 5 portions » ? (3 pts)
5. Indiquez trois limites de cette évaluation. (3 pts)
6. Proposez une adaptation du programme pour les salariés restés en précontemplation. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 3.25

1. Légendes : 1 Précontemplation ; 2 pas d'intention de changer dans les 6 mois ; 3 Contemplation ; 4 intention de changer dans les 6 mois, ambivalence ; 5 Préparation ; 6 changement prévu dans le mois, premiers essais ; 7 Action ; 8 changement en cours depuis moins de 6 mois ; 9 Maintien ; 10 changement installé depuis plus de 6 mois ; 11 Rechute ; 12 retour à l'ancien comportement, puis nouvelle entrée dans le cycle.
2. a) maintien ; b) précontemplation ; c) préparation ; d) contemplation ; e) action ; f) rechute.
3. b) précontemplation : informer sans insister, faire réfléchir (« Que savez-vous des liens entre sucre et diabète ? »), respecter son choix, laisser une porte ouverte. d) contemplation : explorer l'ambivalence (balance avantages et inconvénients), chercher des solutions aux obstacles (marche courte, activité adaptée aux genoux comme l'aquagym). f) rechute : dédramatiser, valoriser les six mois réussis, analyser ce qui a provoqué la rechute (été, invitations) et préparer une nouvelle tentative.

Corrigé – Exercice 3.26

1. Légendes : 1 Attitude ; 2 ce que je pense des conséquences du comportement ; 3 Norme subjective ; 4 ce que pensent et font les personnes qui comptent pour moi ; 5 Contrôle comportemental perçu ; 6 ma capacité ressentie à réaliser le comportement ; 7 Intention ; 8 Comportement.
2. a) attitude ; b) norme subjective (injonctive) ; c) contrôle comportemental perçu ; d) intention ; e) norme (descriptive) ; f) attitude (croyance sur une conséquence).
3. Le contrôle perçu agit sur l'intention (je n'ai pas l'intention de faire ce que je me crois incapable de faire) et directement sur le comportement, parce qu'il reflète en partie le contrôle réel : même avec une forte intention, on ne peut pas faire ce que la situation empêche.
4. Le modèle suppose des décisions réfléchies ; or beaucoup de comportements alimentaires sont des habitudes automatiques, influencées par l'environnement, les émotions et l'offre. Il existe aussi un écart fréquent entre l'intention et le comportement.

Corrigé – Exercice 3.27

1. Rosenstock (1974) et Becker (1974) : la personne agit pour sa santé si elle se sent vulnérable (vulnérabilité perçue), si elle juge la maladie grave (gravité perçue), si elle pense que l'action est utile (bénéfices perçus) et que ses obstacles sont surmontables (obstacles perçus), si un événement la déclenche (incitations à l'action) et si elle se sent capable d'agir (efficacité personnelle, ajoutée en 1988 par Rosenstock, Strecher et Becker).
2. a) vulnérabilité perçue faible (fausse croyance) ; b) gravité perçue ; c) bénéfices perçus ; d) obstacles perçus ; e) incitation à l'action ; f) efficacité personnelle faible.
3. Vulnérabilité : informer que le diabète de type 2 est lié à l'âge, à l'hérédité, au poids et à la sédentarité, et pas seulement au sucre (affiches avec des hommes de 50 ans). Obstacles : proposer le dépistage le samedi ou sur le lieu de travail, expliquer que c'est une piqûre au bout du doigt. Incitation : invitation personnelle par le pharmacien ou par message de l'assurance maladie. On peut aussi agir sur l'efficacité personnelle : expliquer ce qui se passe après un résultat positif (accompagnement, programme d'éducation).
4. Le modèle ne tient pas compte des émotions, des habitudes, des normes sociales et des inégalités d'accès ; il suppose un calcul rationnel.

Corrigé – Exercice 3.28

1. Albert Bandura (1977) : croyance d'une personne en sa capacité à organiser et réaliser les actions nécessaires pour atteindre un but. Elle influence le choix des activités, l'effort fourni et la persévérance

face aux difficultés.

2. a) expériences de maîtrise (réussites personnelles, avec une difficulté progressive) ; b) expériences vicariantes (observer un modèle qui réussit) ; c) persuasion verbale (encouragements précis) ; d) états physiologiques et émotionnels (réduire l'anxiété pour que la personne n'interprète pas son stress comme un signe d'incapacité).

3. Les expériences de maîtrise : réussir soi-même est la preuve la plus convaincante de sa capacité. C'est pourquoi un atelier où l'on regarde une démonstration sans pratiquer renforce peu la confiance.

4. L'observateur se compare au modèle : plus le modèle lui ressemble (même situation, mêmes difficultés au départ), plus la réussite du modèle lui paraît accessible (« si elle y arrive, moi aussi »). Un chef cuisinier, perçu comme très différent, peut au contraire décourager.

Corrigé – Exercice 3.29

1. Légendes : 1 Capacité ; 2 physique (savoir-faire, force) et psychologique (connaissances, compétences) ; 3 Opportunité ; 4 physique (temps, argent, équipement, offre) et sociale (normes, soutien) ; 5 Motivation ; 6 réflexive (intentions, croyances) et automatique (habitudes, émotions) ; 7 Comportement.

2. a) capacité psychologique (connaissance) ; b) opportunité physique (accès aux collations) ; c) motivation automatique (habitude, gêne) et opportunité sociale (norme apprise) ; d) opportunité physique (temps, effectif) ; e) opportunité sociale (norme descriptive) ; f) motivation réflexive (croyance sur l'utilité).

3. Éducation, persuasion, incitation, coercition, formation, restriction, restructuration de l'environnement, modélisation (montrer l'exemple), facilitation.

4. Éducation (capacité) : courte formation sur le jeûne nocturne, la dénutrition et ses conséquences, avec des chiffres du service. Restructuration de l'environnement (opportunité physique) : un chariot de collations prêtes (laitages, compotes enrichies) dans le poste de soins, accessible la nuit, et la collation inscrite dans le plan de soins de chaque résident concerné. Modélisation et persuasion (opportunité sociale et motivation) : une aide-soignante référente montre comment proposer la collation sans réveiller (résidents déjà éveillés, au moment d'un change), et l'équipe partage les résultats (poids, prises alimentaires).

5. La formation agit seulement sur la capacité ; or les freins principaux sont des opportunités (cuisine fermée, temps, norme d'équipe) et la motivation (croyance que cela ne sert à rien). Sans changement de l'organisation et de l'environnement, les connaissances nouvelles ne se traduisent pas en comportement.

Corrigé – Exercice 3.30

1. Avant : précontemplation 28 / 80 = 35,0 % ; contemplation 22 / 80 = 27,5 % ; préparation 14 / 80 = 17,5 % ; action 10 / 80 = 12,5 % ; maintien 6 / 80 = 7,5 %. Après : précontemplation 18 / 80 = 22,5 % ; contemplation 20 / 80 = 25,0 % ; préparation 16 / 80 = 20,0 % ; action 15 / 80 = 18,8 % ; maintien 11 / 80 = 13,8 %. Les arrondis des valeurs « après » font 100,1 %.

2. Action ou maintien : avant (10 + 6) / 80 = 16 / 80 = 20,0 % ; après (15 + 11) / 80 = 26 / 80 = 32,5 % ; hausse de 12,5 points.

3. Progression : 34 / 80 = 42,5 % ; stabilité : 38 / 80 = 47,5 % ; recul : 8 / 80 = 10,0 % ; total 34 + 38 + 8 = 80, soit 100 %.

4. Un indicateur « oui ou non » ne verrait que les salariés qui atteignent 5 portions ; il ignorerait ceux qui passent de la précontemplation à la contemplation ou à la préparation, qui sont pourtant des progrès réels et des étapes nécessaires. Les stades permettent aussi de repérer les reculs (10 %) et d'adapter les actions à chaque stade.

5. Volontaires probablement déjà motivés (biais de sélection) ; données déclaratives (désirabilité sociale) ; pas de groupe témoin : l'évolution peut être due à la saison (été, fruits moins chers) ; stades mesurés par une seule question ; suivi court (6 mois ne permet pas de juger le maintien).

6. Pour la précontemplation : ne pas insister sur l'objectif de 5 portions ; susciter la curiosité et le plaisir

(dégustations de fruits de saison, défis d'équipe ludiques), informer sans culpabiliser, faire intervenir des collègues qui ont changé (modèles), et agir sur l'environnement (fruits disponibles et gratuits) qui touche tout le monde sans demander d'effort.

Partie 6 – Communiquer, écouter, accompagner la motivation

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender le schéma de la communication et repérer les obstacles (bruits) dans une situation professionnelle.
- Reconnaître les attitudes de Porter et utiliser l'écoute active (questions ouvertes, reformulation, résumé).
- Appliquer l'esprit et les outils de l'entretien motivationnel ; repérer le discours-changement ; construire une balance décisionnelle.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Schéma de la communication : émetteur, message, code, canal, récepteur, bruits, rétroaction (d'après Shannon et Weaver, 1949, complété par la rétroaction).
- Communication verbale (les mots), paraverbale (ton, débit, volume) et non verbale (posture, gestes, regard, distance).
- Attitudes de Porter (1950) : évaluation, interprétation, soutien, investigation, solution, compréhension. L'attitude de compréhension (reformulation) favorise le plus l'expression.
- Écoute active (Rogers) : empathie, acceptation inconditionnelle, authenticité ; questions ouvertes, reformulation, silence, résumé.
- Entretien motivationnel (Miller et Rollnick, 3e édition, 2013) : esprit fait de partenariat, acceptation, compassion et évocation ; quatre processus (engager, focaliser, évoquer, planifier) ; outils : questions ouvertes, valorisation, reflets, résumés. On repère le discours-changement (désir, capacité, raisons, besoin, engagement) et le discours-maintien.

Exercice 3.31 – Légender le schéma de la communication (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous avez animé une séance d'information sur l'allaitement dans une salle municipale. Votre tutrice a noté plusieurs problèmes pendant la séance.

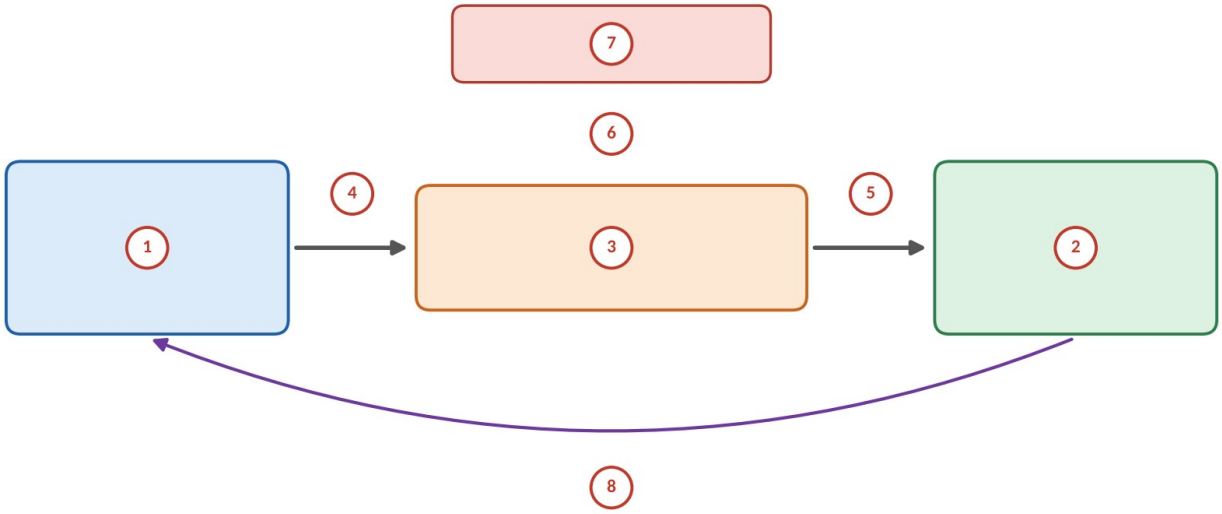


Figure 3.10 – Document 1 – Le schéma de la communication (schéma à légender)

Document 2 – Notes de la tutrice

a) Des travaux de voirie faisaient beaucoup de bruit pendant la première demi-heure.

b) Vous avez utilisé les mots « colostrum », « montée de lait » et « tire-allaitement » sans les expliquer.

c) Deux mamans ne parlaient que le tamoul.

d) Vous parliez vite en regardant vos diapositives.

e) Une maman pensait que l'allaitement « fait tomber les seins » et n'a rien entendu d'autre.

f) Vous n'avez pas demandé si les participantes avaient des questions.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Classez chaque note : bruit physique, bruit sémantique (code), bruit psychologique (représentations, émotions), défaut de rétroaction, problème de canal ou d'attitude non verbale. (3 pts)
3. Proposez une correction pour trois de ces problèmes. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.32 – Reconnaître les attitudes de Porter (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un atelier pour des aidants, une femme dit : « Mon mari ne mange presque plus depuis qu'il est malade. Je lui prépare ce qu'il aimait, il repousse l'assiette. Je ne sais plus quoi faire, je suis épuisée. »

Document 1 – Six réponses possibles

a) « Vous devriez lui proposer des petites portions enrichies, plusieurs fois par jour. »

b) « Ce n'est pas bien de vous épuiser ainsi, il faut penser à vous. »

c) « Vous vous sentez démunie et fatiguée de voir vos efforts refusés. »

d) « Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger, beaucoup de malades retrouvent l'appétit. »

e) « Depuis quand ne mange-t-il plus ? A-t-il perdu du poids ? »

f) « En fait, vous culpabilisez parce que vous pensez que c'est votre cuisine qui ne va pas. »

À vous de jouer – Questions

1. **1.** Associez chaque réponse à une attitude de Porter. (6 pts)
2. **2.** Indiquez les effets probables des réponses b) et d) sur la personne. (2 pts)
3. **3.** Expliquez pourquoi la réponse c) est la plus adaptée au début de l'échange. (2 pts)
4. **4.** Indiquez à quel moment l'attitude de solution devient utile. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.33 – Questions ouvertes et reformulations (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous relisez la transcription d'un entretien que vous avez mené avec un jeune homme de 22 ans qui vient d'apprendre qu'il a un diabète de type 2. Votre tutrice vous demande de réécrire certaines de vos interventions.

Document 1 – Vos interventions

1. « Vous mangez des fruits tous les jours ? »
2. « Vous avez compris ce que vous a dit le médecin ? »
3. « Est-ce que vous faites du sport ? »
4. Le jeune homme : « Franchement, je ne vois pas comment je vais faire, je travaille en livraison toute la journée et je mange dans le camion. » Vous : « Il faut prévoir votre repas la veille. »
5. Le jeune homme : « Mon père aussi était diabétique, il est mort à 58 ans. » Vous : « D'accord. Et le soir, vous mangez quoi ? »

À vous de jouer – Questions

1. Distinguez question ouverte et question fermée ; transformez les interventions 1, 2 et 3 en questions ouvertes. (4 pts)
2. Pour l'intervention 4, proposez un reflet simple et un reflet complexe. (4 pts)
3. Pour l'intervention 5, expliquez l'erreur et proposez une meilleure réponse. (2 pts)
4. Rédigez un résumé de fin d'entretien de trois phrases. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.34 – Discours-changement et esprit de l'entretien motivationnel (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un groupe de parole dans un programme d'éducation thérapeutique pour des personnes ayant une hypertension. Vous notez des phrases des participants.

Document 1 – Phrases entendues

a) « J'aimerais bien manger moins salé. »

b) « Je pourrais remplacer le cube de bouillon par des herbes. »

c) « Si je mange moins salé, je pourrai peut-être diminuer un médicament. »

d) « Il faut que je fasse quelque chose, ma tension est trop haute. »

e) « Cette semaine, je ne rachète pas de chips. »

f) « Sans sel, tout est fade, je n'y arriverai jamais. »

g) « Mon père salait tout et il est mort vieux. »

À vous de jouer – Questions

1. Présentez les quatre éléments de l'esprit de l'entretien motivationnel. (4 pts)
2. Classez chaque phrase : discours-changement (désir, capacité, raison, besoin, engagement) ou discours-maintien. (4 pts)
3. Proposez une réponse en entretien motivationnel à la phrase f), sans argumenter contre la personne. (2 pts)
4. Expliquez le « réflexe correcteur » et pourquoi il faut l'éviter. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.35 – Construire une balance décisionnelle (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un entretien, M. T., 45 ans, chauffeur de bus, envisage d'arrêter de grignoter des viennoiseries pendant ses pauses. Vous construisez avec lui une balance décisionnelle et il note l'importance de chaque élément de 1 (peu important) à 5 (très important).

Document 1 – La balance de M. T.

Case	Éléments cités par M. T. (importance)
Avantages de continuer	plaisir de la pause (4) ; facilité, la boulangerie est au terminus (3)
Inconvénients de continuer	fatigue après le sucre (4) ; culpabilité (3) ; coût, environ 30 € par mois (2)
Avantages de changer	plus d'énergie l'après-midi (4) ; économies (3) ; meilleure glycémie, son médecin l'a alerté (5)
Inconvénients de changer	perte d'un moment de plaisir (4) ; il faut préparer une collation la veille (3)

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le total des éléments en faveur du changement (avantages de changer et inconvénients de continuer) et le total en faveur du statu quo. (3 pts)
2. Interprétez le résultat ; dites dans quel stade du changement se trouve probablement M. T. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi il ne faut pas négliger les éléments en faveur du statu quo. (2 pts)
4. Proposez, avec lui, une solution qui garde le plaisir de la pause. (2 pts)
5. Indiquez la limite d'une balance chiffrée. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.36 – Analyser un entretien avec des indicateurs (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour progresser, vous avez enregistré (avec l'accord écrit de la personne) 12 minutes d'un entretien de suivi diététique. Votre tutrice code vos interventions avec une grille inspirée de l'outil MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity, version 4.2.1, Moyers et ses collègues, 2016).

Document 1 – Codage de vos interventions (12 minutes)

Type d'intervention	Nombre
Questions fermées	13
Questions ouvertes	5
Reflets simples	7
Reflets complexes	2
Valorisations	2
Conseils donnés sans demander la permission	4

Repères du MITI 4.2.1 : rapport reflets / questions « correct » à partir de 1 et « bon » à partir de 2 ; part des reflets complexes parmi les reflets « correcte » à partir de 40 % et « bonne » à partir de 50 %.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre total de questions et de reflets, le rapport reflets / questions, la part des reflets complexes et la part des questions ouvertes. (5 pts)
2. Comparez vos résultats aux repères et rédigez votre auto-évaluation. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi les conseils donnés sans permission posent problème, et comment demander la permission. (3 pts)
4. Fixez-vous trois objectifs chiffrés pour le prochain entretien enregistré. (3 pts)
5. Indiquez les règles éthiques de l'enregistrement d'un entretien. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 3.31

1. Légendes : 1 Émetteur ; 2 Récepteur ; 3 Message ; 4 codage ; 5 décodage ; 6 Canal : oral, écrit, image, gestes, numérique ; 7 Bruits : obstacles ; 8 Rétroaction (feed-back) : le récepteur montre ce qu'il a compris.
2. a) bruit physique ; b) bruit sémantique (code non partagé) ; c) bruit sémantique (langue) et problème de canal ; d) attitude non verbale et paraverbale (débit, regard) ; e) bruit psychologique (représentation, inquiétude) ; f) défaut de rétroaction.
3. b) expliquer chaque mot technique avec un exemple ou une image, ou utiliser des mots simples ; c) prévoir une interprète ou des supports illustrés traduits, vérifier les besoins linguistiques à l'inscription ; d) parler lentement, regarder le public, utiliser les diapositives comme appui ; e) partir des représentations au début de la séance (« Qu'avez-vous entendu dire sur l'allaitement ? ») ; f) prévoir des temps de questions et vérifier la compréhension (« Qu'est-ce que vous retenez ? »).

Corrigé – Exercice 3.32

1. a) solution ; b) évaluation (jugement moral) ; c) compréhension (reformulation empathique) ; d) soutien (réconfort, minimisation) ; e) investigation ; f) interprétation.
2. b) la personne se sent jugée et culpabilisée, elle peut se justifier ou se fermer. d) la personne se sent rassurée un moment mais non entendue ; son épuisement est minimisé et l'échange s'arrête.
3. La reformulation montre qu'on a compris ce qu'elle vit (empathie) sans juger ni conseiller ; elle l'invite à continuer à parler et à préciser elle-même la situation, ce qui permet ensuite de trouver des solutions adaptées.
4. Quand la personne a pu s'exprimer, que la situation est bien comprise et qu'elle demande des idées (ou accepte qu'on lui en propose) : on propose alors des solutions, en lui laissant le choix.

Corrigé – Exercice 3.33

1. Une question fermée appelle une réponse courte (oui, non, un chiffre) ; une question ouverte invite la personne à développer. Exemples : 1. « Comment se passent vos journées côté repas ? » ; 2. « Qu'avez-vous retenu de ce que vous a dit le médecin ? » ; 3. « Quelle place l'activité physique a-t-elle dans votre vie ? »
2. Reflet simple : « Vous ne voyez pas comment faire avec votre travail de livreur. » Reflet complexe : « Vous avez envie de prendre soin de votre santé, mais votre travail vous laisse très peu de place pour les repas. »
3. Le jeune homme exprime une émotion forte (la mort de son père, sans doute de la peur) ; la question suivante l'ignore. Meilleure réponse : « Vous avez vu ce que le diabète a fait à votre père, et vous avez peur pour vous. » puis laisser un silence.
4. Exemple : « Si je résume, vous venez d'apprendre votre diabète et cela vous fait penser à votre père. Votre travail en livraison rend les repas difficiles, mais vous voulez éviter ce qui lui est arrivé. On a parlé de deux idées de repas à emporter que vous allez essayer cette semaine ; est-ce que j'ai bien résumé ? »

Corrigé – Exercice 3.34

1. Partenariat : le professionnel et la personne collaborent, la personne est experte de sa vie. Acceptation : respect de la valeur de la personne, de son autonomie, empathie et valorisation. Compassion : agir pour le bien de la personne. Évocation : faire émerger les motivations et les ressources de la personne plutôt que de les lui apporter.
2. a) discours-changement : désir ; b) capacité ; c) raison ; d) besoin ; e) engagement ; f) discours-maintien (et

faible capacité perçue) ; g) discours-maintien.

3. Exemple : « Le goût compte beaucoup pour vous, et vous avez peur que les plats deviennent fades. En même temps, vous avez dit que vous aimeriez manger moins salé. Qu'est-ce qui pourrait donner du goût sans le sel ? »

4. Le réflexe correcteur est l'envie de corriger tout de suite la personne, de la convaincre ou de lui donner la solution. Il provoque souvent l'effet inverse : la personne défend l'autre côté de son ambivalence (discours-maintien) et se sent jugée. L'entretien motivationnel cherche au contraire à faire exprimer les raisons de changer par la personne elle-même.

Corrigé – Exercice 3.35

1. En faveur du changement : avantages de changer 4 + 3 + 5 = 12 ; inconvénients de continuer 4 + 3 + 2 = 9 ; total 12 + 9 = 21. En faveur du statu quo : avantages de continuer 4 + 3 = 7 ; inconvénients de changer 4 + 3 = 7 ; total 7 + 7 = 14.

2. La balance penche vers le changement (21 contre 14, soit 1,5 fois plus), mais les deux côtés restent présents : M. T. est ambivalent. Il est probablement en contemplation ou en préparation : il envisage le changement, il a des raisons fortes (alerte du médecin, importance 5), mais il n'a pas encore agi.

3. Les avantages du statu quo (plaisir, facilité) sont réels ; si on les ignore, le changement prévu les fera perdre sans compensation et la rechute est probable. Les reconnaître montre l'acceptation et aide à chercher une solution qui garde ce qui compte pour la personne.

4. Garder la pause et le moment de plaisir, mais changer le contenu : une collation choisie par lui et préparée la veille (fruit, pain et fromage, poignée d'oléagineux) ; ou une viennoiserie une fois par semaine au lieu de chaque jour ; ou partager la pause avec un collègue. C'est lui qui choisit.

5. Les notes sont subjectives et peuvent changer d'un jour à l'autre ; additionner des éléments très différents a peu de sens ; un seul élément très fort (alerte du médecin, plaisir) peut peser plus que tous les autres. La balance sert surtout à faire parler la personne, pas à prendre la décision à sa place.

Corrigé – Exercice 3.36

1. Questions : 13 + 5 = 18. Reflets : 7 + 2 = 9. Rapport reflets / questions = 9 / 18 = 0,5. Part des reflets complexes = 2 / 9 × 100 = 22,2 %. Part des questions ouvertes = 5 / 18 × 100 = 27,8 %.

2. Le rapport de 0,5 est sous le seuil « correct » de 1 : je pose deux fois plus de questions que je ne fais de reflets. La part de reflets complexes (22,2 %) est sous le seuil de 40 %. J'utilise surtout des questions fermées (72,2 %) : l'entretien ressemble à un interrogatoire et la personne parle peu. J'ai cependant valorisé deux fois la personne, ce qui est un point d'appui.

3. Un conseil non demandé place le professionnel en expert qui sait mieux que la personne ; il provoque souvent de la résistance (« oui, mais… ») et réduit l'autonomie. Demander la permission : « Est-ce que vous voulez que je vous donne quelques idées que d'autres personnes ont trouvées utiles ? », puis laisser la personne choisir ce qui lui convient (« Qu'est-ce qui vous paraît possible pour vous ? »).

4. Exemples : au moins autant de reflets que de questions (rapport d'au moins 1) ; au moins 40 % de reflets complexes ; au moins la moitié de questions ouvertes ; aucun conseil sans permission.

5. Accord écrit et libre de la personne, après une information claire sur le but (formation), l'usage et la durée de conservation ; possibilité de refuser ou d'arrêter l'enregistrement sans conséquence sur la prise en charge ; stockage sécurisé, accès limité à la tutrice, suppression après l'analyse ; anonymisation de la transcription.

Partie 7 – Animer un groupe, motiver, tenir compte des biais de décision

Objectifs – Objectifs de la partie

- Reconnaître les étapes de la vie d'un groupe (Tuckman), les rôles des membres (Benne et Sheats) et les styles d'animation (Lewin, Lippitt et White).
- Choisir une technique d'animation adaptée à un objectif.
- Situer une motivation sur le continuum de l'autodétermination (Deci et Ryan) ; utiliser les biais cognitifs et les « coups de pouce » (nudges) de façon éthique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Étapes d'un groupe (Tuckman, 1965 ; Tuckman et Jensen, 1977) : formation, tension, normalisation, production, dissolution.
- Rôles (Benne et Sheats, 1948) : rôles centrés sur la tâche (proposer, informer, résumer), rôles centrés sur l'entretien du groupe (encourager, concilier, faciliter la parole), rôles individuels qui gênent le groupe (bloquer, dominer, se mettre en avant).
- Styles d'animation (Lewin, Lippitt et White, 1939) : autoritaire, démocratique (participatif), laisser-faire.
- Théorie de l'autodétermination (Deci et Ryan, 1985 ; Ryan et Deci, 2000) : trois besoins (autonomie, compétence, appartenance) ; continuum : amotivation, régulation externe, introjectée, identifiée, intégrée, motivation intrinsèque.
- Biais cognitifs : biais du présent, statu quo et option par défaut, ancrage, effet de halo (un mot « santé » qui fait juger tout le produit sain). Nudge (Thaler et Sunstein, 2008) : modification de l'environnement de choix qui oriente sans interdire ni changer les prix.

Exercice 3.37 – Légender les étapes de la vie d'un groupe (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un cycle de 8 ateliers cuisine pour 10 adultes dans un centre social. Vous notez dans votre carnet de bord ce qui se passe à chaque séance.

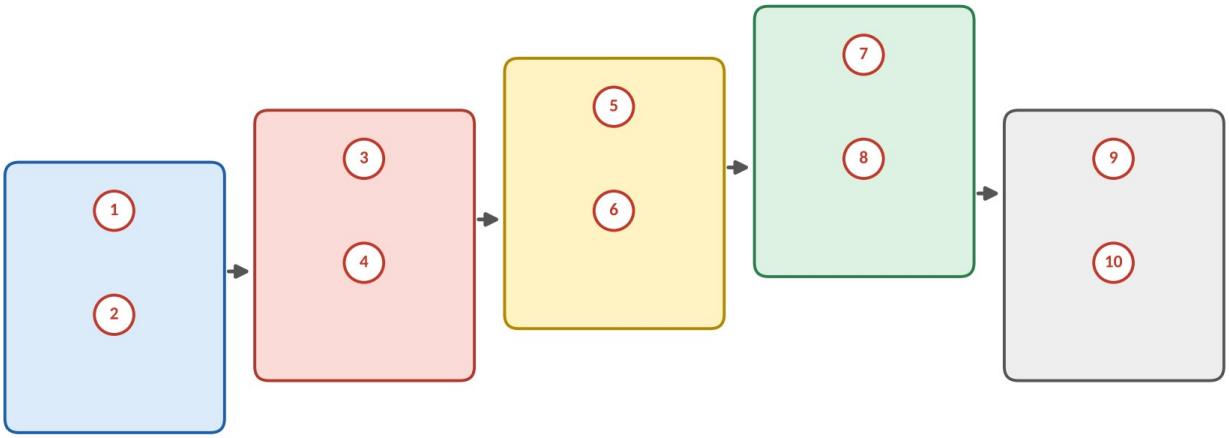


Figure 3.11 – Document 1 – Les étapes de la vie d'un groupe (schéma à légender)

Document 2 – Extraits du carnet de bord

a) Séance 1 : les participants sont polis, attendent mes consignes, parlent peu entre eux.

b) Séance 3 : deux participantes se disputent sur la façon de couper les légumes ; un participant dit que mes recettes « ne servent à rien ».

c) Séance 5 : le groupe a adopté ses règles (chacun goûte, on range ensemble) ; une bonne ambiance s'installe.

d) Séance 7 : les participants organisent eux-mêmes la répartition des tâches et proposent une recette.

e) Séance 8 : repas de fin de cycle, bilan, échange de numéros de téléphone.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (5 pts)
2. Associez chaque extrait du carnet à une étape. (2,5 pts)
3. Indiquez le rôle de l'animateur à l'étape de tension. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.38 – Les rôles dans un groupe (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous observez une réunion de 8 parents qui préparent une fête de quartier avec un buffet « sain et pas cher ».

Document 1 – Ce que font les parents

a) Mme A. propose de faire un buffet de crudités et de tartinades de légumineuses.

b) M. B. rappelle le budget et le nombre d'invités prévus.

c) Mme C. encourage Mme D., très timide, à donner son avis.

d) M. E. coupe la parole à tout le monde et raconte ses vacances.

e) Mme F. fait la synthèse des décisions à la fin de la réunion.

f) M. G. trouve une solution entre deux parents qui ne sont pas d'accord sur les boissons.

g) Mme H. rejette chaque proposition sans en faire aucune.

À vous de jouer – Questions

1. **1.** Présentez les trois catégories de rôles de Benne et Sheats (1948). (3 pts)
2. **2.** Classez chaque comportement du document 1. (4 pts)
3. **3.** Proposez une façon de gérer M. E. et Mme H. sans les humilier. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.39 – Styles d'animation et participation (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une épicerie sociale, trois stagiaires ont animé chacune un atelier d'une heure sur les menus à petit budget, avec des groupes de 12 personnes. Une observatrice a mesuré leur temps de parole et compté les participants qui ont pris la parole au moins une fois.

Document 1 – Observations (données fictives)

Stagiaire	Temps de parole de l'animatrice (sur 60 min)	Participants qui ont pris la parole	Menus réalisés en fin d'atelier
Animatrice 1	42 min	3 sur 12	1 menu, rédigé par l'animatrice
Animatrice 2	18 min	11 sur 12	3 menus, rédigés par les sous-groupes
Animatrice 3	6 min	5 sur 12	aucun menu terminé

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part du temps de parole de chaque animatrice et la part des participants qui ont pris la parole. (3 pts)
2. Associez chaque animatrice à un style de Lewin, Lippitt et White (1939) et justifiez. (3 pts)
3. Présentez les effets connus de chaque style sur le groupe. (3 pts)
4. Indiquez dans quelle situation un style plus directif est justifié. (1 pt)
5. Indiquez une limite de cette observation. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.40 – Choisir une technique d'animation (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un cycle d'ateliers pour des étudiants en résidence universitaire. Vous avez cinq objectifs différents et une liste de techniques.

Document 1 – Objectifs et techniques

Objectifs : A. faire émerger les représentations du « repas étudiant » ; B. produire en 20 minutes une liste d'idées de repas à moins de 2 € ; C. faire prendre position sur la phrase « manger sain coûte cher » ; D. s'entraîner à refuser une soirée « fast-food » sans se fâcher avec ses amis ; E. classer et regrouper les idées produites par tout le groupe.

Techniques : photolangage ; brainstorming (remue-méninges) ; débat mouvant ; jeu de rôle ; métaplan.

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque objectif à la technique la plus adaptée. (5 pts)
2. Décrivez le déroulement du débat mouvant et ses règles. (3 pts)
3. Indiquez deux précautions pour animer un jeu de rôle. (2 pts)
4. Indiquez l'intérêt d'alterner les techniques au cours d'un cycle. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.41 – Motivation, biais et coups de pouce à la cantine (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le restaurant universitaire d'un campus sert 1 600 repas par jour. Le plat végétarien était proposé en dernière position sur la ligne de self. Pendant un mois, l'équipe l'a placé en première position, lui a donné un nom appétissant et l'a servi en assiette déjà composée par défaut (l'autre plat restant disponible sur demande).

Document 1 – Résultats (données fictives, moyenne par jour)

Avant : 220 plats végétariens sur 1 600 repas. Pendant le mois de test : 512 plats végétariens sur 1 600 repas. Enquête auprès de 200 étudiants : 22 disent ne pas avoir remarqué de changement ; 9 disent s'être sentis « manipulés ».

Document 2 – Ce que disent des étudiants de leur alimentation

a) « Je mange des légumes parce que ma mère m'appelle tous les soirs pour vérifier. »

b) « J'adore cuisiner, c'est mon moment préféré de la journée. »

c) « Je mangerais mieux pour me sentir moins coupable. »

d) « Bien manger, c'est important pour réussir mes examens, j'ai compris pourquoi. »

e) « Manger équilibré, ça fait partie de qui je suis, comme le sport et l'écologie. »

f) « Je ne vois pas l'intérêt, je mange ce qui passe. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part des plats végétariens avant et pendant le test, l'écart en points et le rapport. (3 pts)
2. Identifiez les trois leviers (biais) utilisés par l'équipe. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi cette démarche est un nudge, et discutez son caractère éthique en utilisant l'enquête. (3 pts)
4. Placez chaque phrase du document 2 sur le continuum de l'autodétermination. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi les formes de motivation les plus autonomes sont les plus durables. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.42 – Animer un groupe difficile (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans un établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) qui accueille en internat des jeunes de 17 à 25 ans. Vous animez un atelier de 2 heures sur l'alimentation avec 14 volontaires. Après 20 minutes, la situation se dégrade : trois jeunes discutent entre eux et rient, un jeune dit à voix haute que « la nutrition, c'est pour les meufs au régime », deux jeunes regardent leur téléphone, et une jeune femme ne dit rien et semble mal à l'aise. Votre tutrice est présente mais vous laisse gérer.

À vous de jouer – Questions

1. Analysez la situation avec trois notions du chapitre (étape du groupe, rôles, normes de genre, besoins de l'autodétermination). (5 pts)
2. Proposez une réponse immédiate pour reprendre le groupe, sans autoritarisme ni humiliation. (3 pts)
3. Proposez trois modifications de votre atelier pour la séance suivante, chacune justifiée. (4 pts)
4. Rédigez trois règles du groupe que vous ferez construire par les jeunes, et la façon de les construire. (2 pts)
5. Indiquez ce que vous faites pour la jeune femme silencieuse. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 3.37

1. Légendes : 1 Formation ; 2 on se découvre, on attend des consignes ; 3 Tension ; 4 désaccords, rivalités, contestation de l'animateur ; 5 Normalisation ; 6 règles acceptées, cohésion ; 7 Production ; 8 le groupe travaille de façon autonome ; 9 Dissolution ; 10 fin du groupe, bilan, séparation.
2. a) formation ; b) tension ; c) normalisation ; d) production ; e) dissolution.
3. Accepter les désaccords comme une étape normale ; faire exprimer les points de vue sans prendre parti ; rappeler et faire construire les règles du groupe ; reformuler les critiques (« vous avez besoin de recettes plus utiles pour votre quotidien ») et associer le groupe aux choix ; ne pas se sentir attaqué personnellement.

Corrigé – Exercice 3.38

1. Rôles centrés sur la tâche : ils font avancer le travail (proposer, informer, résumer, coordonner). Rôles centrés sur l'entretien du groupe : ils maintiennent de bonnes relations (encourager, concilier, faciliter la parole). Rôles individuels : ils servent les besoins personnels au détriment du groupe (dominer, bloquer, se mettre en avant, rechercher l'attention).
2. a) tâche (proposer) ; b) tâche (informer, rappeler les données) ; c) entretien (encourager, faciliter la parole) ; d) individuel (dominer, rechercher l'attention) ; e) tâche (résumer, synthétiser) ; f) entretien (concilier) ; g) individuel (bloquer).
3. M. E. : le remercier et recentrer (« Merci, revenons au buffet : qu'est-ce que vous pourriez apporter ? ») ; organiser des tours de parole ou un objet de parole ; lui confier une tâche (gardien du temps). Mme H. : reformuler ses objections et lui demander une proposition (« Qu'est-ce qui vous conviendrait mieux ? ») ; reconnaître ce qui la gêne (budget, temps) ; si le blocage continue, en parler avec elle en dehors du groupe.

Corrigé – Exercice 3.39

1. Temps de parole : animatrice 1 : 42 / 60 × 100 = 70,0 % ; animatrice 2 : 18 / 60 × 100 = 30,0 % ; animatrice 3 : 6 / 60 × 100 = 10,0 %. Participants qui ont parlé : 3 / 12 = 25,0 % ; 11 / 12 = 91,7 % ; 5 / 12 = 41,7 %.
2. Animatrice 1 : autoritaire (directif) : elle parle 70 % du temps et rédige elle-même le menu. Animatrice 2 : démocratique (participatif) : elle parle peu, presque tous les participants s'expriment, les sous-groupes produisent. Animatrice 3 : laisser-faire : elle intervient très peu, le groupe ne s'organise pas et ne termine rien.
3. Autoritaire : production rapide mais dépendante de l'animateur, faible participation, parfois tension ou passivité ; la production s'arrête quand l'animateur s'en va. Démocratique : participation, satisfaction et cohésion plus fortes, production de bonne qualité et plus autonome. Laisser-faire : désorganisation, faible production, insatisfaction.
4. Lorsqu'il y a un enjeu de sécurité (utilisation d'un couteau, d'une plaque chaude, règle d'hygiène), lorsque le temps est très court, ou au tout début d'un groupe qui a besoin de repères.
5. Une seule séance par animatrice ; groupes différents (participants plus ou moins à l'aise) ; observatrice qui connaît le but de l'observation ; le temps de parole ne mesure pas la qualité des interventions.

Corrigé – Exercice 3.40

1. A : photolangage ; B : brainstorming ; C : débat mouvant ; D : jeu de rôle ; E : métaplan.
2. L'animateur lit une affirmation volontairement discutable (« manger sain coûte cher ») ; les participants se placent d'un côté de la salle (d'accord) ou de l'autre (pas d'accord), sans position intermédiaire ; chaque camp donne à tour de rôle un argument ; on peut changer de côté si un argument nous convainc. Règles : écouter sans interrompre, parler de l'idée et pas de la personne, droit de changer d'avis. L'animateur fait

ensuite une synthèse et apporte des informations (prix au kilo, coût des légumineuses).

3. Laisser chacun libre de jouer ou d'observer ; définir clairement le scénario et les rôles ; sortir du rôle à la fin (« dérôler ») ; débriefing centré sur ce qui a fonctionné, sans juger la personne ; éviter les situations trop proches de la vie privée.
4. Varier les techniques maintient l'attention et la motivation, permet à des profils différents de s'exprimer (à l'oral, à l'écrit, par le corps), et correspond à des objectifs différents : faire émerger, produire, débattre, s'entraîner.

Corrigé – Exercice 3.41

1. Avant : 220 / 1 600 × 100 = 13,8 % ; pendant : 512 / 1 600 × 100 = 32,0 % ; écart : 32,0 − 13,8 = 18,2 points (18,25 points avec les valeurs exactes 13,75 % et 32,0 %) ; rapport : 512 / 220 = 2,33. La part des plats végétariens a été multipliée par 2,3.
2. Position (effet de primauté : on choisit plus souvent ce qu'on voit en premier) ; option par défaut (biais du statu quo : on garde ce qui est proposé) ; nom appétissant (cadrage, attractivité, effet de halo positif).
3. C'est un nudge parce que le choix reste libre (l'autre plat est disponible), le prix ne change pas et rien n'est interdit : seul l'environnement de choix est modifié (Thaler et Sunstein, 2008). Sur le plan éthique, 9 étudiants sur 200 (4,5 %) se sont sentis manipulés et 22 (11,0 %) n'ont rien remarqué : un nudge est plus acceptable s'il est transparent (affiche qui explique la démarche), s'il sert l'intérêt des personnes et s'il reste facile de choisir autrement. Des études réelles vont dans le même sens : dans des restaurants universitaires de Cambridge, doubler la part des plats végétariens proposés a augmenté leurs ventes de 40 à 80 % (Garnett et ses collègues, PNAS, 2019).
4. a) régulation externe (contrôle de la mère) ; b) motivation intrinsèque (plaisir de l'activité) ; c) régulation introjectée (éviter la culpabilité) ; d) régulation identifiée (importance personnelle comprise) ; e) régulation intégrée (cohérente avec son identité et ses valeurs) ; f) amotivation.
5. Les motivations autonomes (identifiée, intégrée, intrinsèque) viennent de la personne : elles ne dépendent ni d'une surveillance ni d'une récompense, elles résistent mieux aux difficultés et donnent du bien-être. Les motivations contrôlées s'arrêtent quand la contrainte disparaît (la mère n'appelle plus) ou s'accompagnent de culpabilité et d'anxiété.

Corrigé – Exercice 3.42

1. Étape du groupe : le groupe est en formation ou déjà en tension ; les jeunes testent le cadre et l'animatrice. Rôles individuels : rires et apartés (recherche d'attention), remarque provocatrice (dominer, bloquer), retrait (téléphone, silence). Normes de genre : « la nutrition, c'est pour les meufs » montre que s'intéresser à l'alimentation menace l'identité masculine dans ce groupe ; la remarque peut aussi blesser la jeune femme. Autodétermination : les besoins d'autonomie (ils subissent un contenu qu'ils n'ont pas choisi), de compétence (ils se sentent jugés sur un sujet « scolaire ») et d'appartenance (le groupe se fait contre l'animatrice) ne sont pas satisfaits.
2. Garder son calme, ne pas entrer dans le conflit ni humilier ; faire une pause active : « Je vois que ce que je propose ne vous parle pas beaucoup. Qu'est-ce qui vous intéresserait, vous, dans l'alimentation ? » ; reformuler la provocation en question ouverte (« Pour toi, la nutrition, c'est quoi ? Et pour un sportif ? ») ; passer à une activité en petits groupes avec une tâche concrète (défi « repas à moins de 3 € qui donne de la force »). Rappeler calmement la règle du respect si la remarque vise quelqu'un.
3. Partir de leurs intérêts (sport, budget, force, insertion professionnelle) en les interrogeant avant l'atelier ; proposer une activité pratique dès le début (cuisine, dégustation, défi) plutôt qu'un exposé ; donner des choix (autonomie) ; faire intervenir un modèle crédible (ancien jeune de l'EPIDE, sportif) ; prévoir des temps courts et rythmés ; former des sous-groupes mixtes et choisis.
4. Exemples : « On respecte les goûts et le corps de chacun, aucune moquerie » ; « Les téléphones restent dans le sac sauf pendant le défi photo » ; « On a le droit de ne pas être d'accord, en le disant poliment ». Construction : chacun écrit sur un post-it ce dont il a besoin pour se sentir bien dans le groupe, on

regroupe, on formule ensemble trois règles et on les affiche.

5. L'inclure sans la mettre en difficulté : travail en binôme ou en petit groupe, possibilité de s'exprimer par écrit ; aller la voir à la pause, lui demander comment elle a vécu la séance ; si la remarque sexiste l'a blessée, la reconnaître ; en parler avec la tutrice et l'équipe éducative si elle semble en souffrance.

Partie 8 – Mesurer les attitudes et les représentations ; cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Construire et coter une échelle de Likert ; utiliser un différenciateur sémantique ; réaliser une analyse de contenu simple.
- Comparer deux proportions avec leurs intervalles de confiance.
- Traiter un cas complet au format de l'épreuve E5 en mobilisant l'ensemble du chapitre.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Échelle de Likert (1932) : série d'affirmations avec des degrés d'accord (souvent 5) ; on inverse les items formulés dans l'autre sens ; on additionne ou on fait la moyenne des items d'une même dimension.
- Règles d'un bon item : une seule idée par item, pas de double négation, des mots simples, pas de jugement implicite, des items positifs et négatifs.
- Différenciateur sémantique (Osgood, Suci et Tannenbaum, 1957) : l'objet est évalué sur des paires d'adjectifs opposés (bon-mauvais, rapide-long), souvent sur 7 positions de − 3 à + 3.
- Analyse de contenu : découper les entretiens en unités de sens, les classer dans des catégories définies à l'avance ou construites à partir du texte, compter les fréquences, illustrer par des citations.
- Intervalle de confiance à 95 % d'une proportion p sur n personnes : p ± 1,96 × racine de (p × (1 − p) / n).

Exercice 3.43 – Repérer les erreurs dans des items (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une collègue a rédigé un questionnaire pour mesurer l'attitude de parents envers la cuisine faite maison. Elle vous demande de le relire.

Document 1 – Items proposés (réponses de « pas du tout d'accord » à « tout à fait d'accord »)

a) « Je n'ai pas l'impression de ne pas savoir cuisiner. »

b) « Cuisiner est rapide et économique. »

c) « Les parents responsables cuisinent pour leurs enfants. »

d) « J'utilise des légumineuses dans mes préparations culinaires hebdomadaires. »

e) « Je cuisine. »

f) « Cuisiner me fait plaisir. »

À vous de jouer – Questions

1. Identifiez l'erreur de chacun des items a) à e). (5 pts)

2. Réécrivez ces cinq items correctement. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.44 – Coter une échelle de Likert (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous utilisez une échelle de 5 items pour mesurer l'attitude envers la cuisine faite maison chez des parents (1 = pas du tout d'accord ; 5 = tout à fait d'accord). Les items 2 et 4 sont négatifs et doivent être inversés (score inversé = 6 − réponse).

Document 1 – Items et réponses de trois parents

Item	Sens	Parent 1	Parent 2	Parent 3
1. Cuisiner me fait plaisir.	positif	5	3	4
2. Cuisiner me prend trop de temps.	négatif	1	3	2
3. Je me sens capable de cuisiner un repas complet.	positif	4	2	5
4. Les plats tout prêts sont aussi bons que les plats maison.	négatif	2	4	1
5. Cuisiner permet de faire des économies.	positif	4	3	5

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le score total (sur 25) et le score moyen par item de chaque parent. (6 pts)

2. Calculez le score moyen des trois parents. (1 pt)

3. Interprétez le profil du parent 2 et proposez un levier d'action adapté. (3 pts)

4. Indiquez ce qu'il faudrait vérifier avant d'utiliser cette échelle à grande échelle. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.45 – Le différenciateur sémantique : légumineuses et pâtes (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Avant de lancer un atelier « légumineuses » dans une maison de quartier, vous avez demandé à 25 adultes d'évaluer les légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots secs) et les pâtes sur six paires d'adjectifs, de − 3 (adjectif de gauche) à + 3 (adjectif de droite).

Document 1 – Moyennes des 25 adultes (données fictives)

Paire d'adjectifs (− 3 à + 3)	Légumineuses	Pâtes
fade – savoureux	+ 0,4	+ 1,9
long à préparer – rapide	− 1,8	+ 2,3
cher – bon marché	+ 2,1	+ 2,0
indigeste – digeste	− 1,2	+ 0,8
démodé – moderne	− 0,9	+ 0,6
peu rassasiant – rassasiant	+ 1,6	+ 1,4

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le score moyen global de chaque aliment. (2 pts)

2. Calculez l'écart (pâtes − légumineuses) pour chaque paire et repérez les deux plus grands écarts. (3 pts)

3. Identifiez les points forts des légumineuses sur lesquels l'atelier peut s'appuyer. (2 pts)

4. Proposez une action pour chacun des deux freins principaux. (3 pts)

5. Expliquez l'intérêt de cet outil par rapport à une question « aimez-vous les légumineuses ? ». (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.46 – Analyse de contenu d'entretiens (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous avez réalisé 6 entretiens semi-directifs avec des parents d'une épicerie sociale sur les freins à la cuisine de légumes frais. Après transcription, vous avez découpé le texte en 120 unités de sens portant sur des freins.

Document 1 – Répartition des 120 unités de sens par catégorie de frein

Catégorie	Nombre d'unités	Exemple de citation
Prix	34	« Les légumes frais, c'est le premier truc que j'enlève du caddie. »
Temps	26	« Le soir, je n'ai pas la force d'éplucher. »
Goût des enfants	22	« Ils ne mangent pas, alors je jette. »
Transport	15	« Le marché, c'est à deux bus d'ici. »
Savoir-faire	14	« Le céleri, je ne sais pas quoi en faire. »
Équipement	9	« J'ai une seule plaque. »

À vous de jouer – Questions

1. Présentez les étapes d'une analyse de contenu. (3 pts)
2. Calculez la part de chaque catégorie et vérifiez le total. (3 pts)
3. Classez les freins selon le modèle COM-B. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi ces pourcentages ne peuvent pas être généralisés à tous les parents de l'épicerie. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.47 – Comparer deux proportions avant et après un cycle d'ateliers (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – recherche appliquée · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de quartier a mené une enquête avant puis après une année d'ateliers « légumineuses ». La question était : « Avez-vous cuisiné des légumineuses au moins une fois par semaine le mois dernier ? » Les personnes interrogées n'étaient pas les mêmes aux deux dates.

Document 1 – Résultats (données fictives)

Avant : 42 « oui » sur 120 personnes interrogées. Après : 63 « oui » sur 115 personnes interrogées.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les deux proportions et l'écart en points. (2 pts)
2. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de chaque proportion. (4 pts)
3. Interprétez : peut-on dire que la proportion a augmenté ? (2 pts)
4. Peut-on attribuer cette évolution aux ateliers ? Justifiez. (2 pts)
5. Proposez un meilleur protocole. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.48 – Cas complet : les gardes de nuit d'une caserne de sapeurs-pompiers (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 h*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage auprès du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours. Le médecin-chef vous confie un projet pour le centre d'incendie et de secours de Saint-Avit (données fictives), qui compte 64 sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Les gardes durent 12 ou 24 heures ; les repas sont préparés et pris en commun à la caserne. Le médecin constate une baisse des résultats aux tests annuels de condition physique et des grignotages importants pendant les gardes de nuit. Il précise : « Ici, la popote, c'est sacré. Il ne faut surtout pas que ça ressemble à un régime. »

Document 1 – Questionnaire anonyme (48 répondants sur 64, données fictives)

Question	Réponses « oui »
Grignote au moins trois fois pendant une garde de nuit	31
Boit des boissons sucrées ou énergisantes pendant les interventions de nuit	22
Prend ses repas en commun à la caserne pendant les gardes	40

Stades du changement pour « réduire le grignotage pendant les gardes de nuit » : précontemplation 14 ; contemplation 16 ; préparation 10 ; action 5 ; maintien 3.

Échelle de Likert (1 à 5), moyennes : « Manger équilibré améliore ma condition physique pour les interventions » : 4,3 ; « À la caserne, on mange gras et sucré, c'est la tradition » : 4,1 ; « Le chef de centre donne l'exemple en mangeant équilibré » : 2,0 ; « Pendant les gardes de nuit, je peux manger équilibré si je le veux » : 2,4.

Document 2 – Ce qu'ils disent

« La popote, c'est ce qui fait l'équipe. » « Celui qui mange de la salade, on le chambre. » « La nuit, entre deux départs, il n'y a que le distributeur et les gâteaux apportés par les collègues. » « Après une intervention difficile, on a besoin de décompresser, et ça passe par le sucre. » « Si on me dit de faire un régime, je n'écoute plus. »

Document 3 – Données et repères réels

L'ANSES (avis de 2016 sur les risques sanitaires des horaires de travail atypiques, notamment de nuit) a conclu à des effets probables du travail de nuit sur la prise de poids, le diabète de type 2 et les maladies coronariennes, et à des effets avérés sur la somnolence et la qualité du sommeil. Budget accordé par le service départemental : 1 200 €.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de réponse, les indicateurs du questionnaire et la répartition par stade (en %). (5 pts)
2. Analysez la situation avec quatre notions de psychologie sociale : identité professionnelle et appartenance au groupe, normes, conformisme, alimentation émotionnelle. (6 pts)
3. Interprétez les moyennes de l'échelle de Likert avec la théorie du comportement planifié et déduisez-en les leviers principaux. (4 pts)
4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et trois objectifs opérationnels. (4 pts)

5. Présentez un plan d'action de quatre actions, chacune justifiée par un concept (norme, modèle, engagement, environnement, efficacité personnelle) et adaptée aux stades. (7 pts)

6. Établissez un budget qui respecte les 1 200 €. (3 pts)

7. Proposez la démarche d'évaluation (processus et résultats). (5 pts)

8. Indiquez les règles éthiques (données de santé, lien avec l'employeur, résultats des tests physiques) et les principes de communication auprès de l'équipe. (6 pts)

Ma réponse

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 3.43

1. a) double négation, difficile à comprendre ; b) deux idées dans un item (rapide et économique) : on ne sait pas à laquelle la personne répond ; c) jugement moral implicite (« responsables ») qui pousse à la désirabilité sociale et culpabilise ; d) vocabulaire compliqué (« légumineuses », « hebdomadaires ») pour un public large ; e) item trop vague (à quelle fréquence ? quoi ?) et qui décrit un comportement, pas une attitude.
2. a) « Je sais cuisiner. » ; b) « Cuisiner est rapide. » et « Cuisiner permet de faire des économies. » (deux items) ; c) « Cuisiner pour mes enfants est important pour moi. » ; d) « Je cuisine des lentilles, des pois chiches ou des haricots secs au moins une fois par semaine. » ; e) « J'aime préparer des repas pour ma famille. » (ou une question de fréquence séparée).

Corrigé – Exercice 3.44

1. Parent 1 : 5 + (6 − 1) + 4 + (6 − 2) + 4 = 5 + 5 + 4 + 4 + 4 = 22 sur 25 ; moyenne 22 / 5 = 4,4. Parent 2 : 3 + (6 − 3) + 2 + (6 − 4) + 3 = 3 + 3 + 2 + 2 + 3 = 13 sur 25 ; moyenne 2,6. Parent 3 : 4 + (6 − 2) + 5 + (6 − 1) + 5 = 4 + 4 + 5 + 5 + 5 = 23 sur 25 ; moyenne 4,6.
2. (22 + 13 + 23) / 3 = 58 / 3 = 19,3 sur 25.
3. Le parent 2 a une attitude plutôt défavorable (2,6 par item, sous le point neutre de 3) ; son score le plus bas porte sur la capacité perçue (item 3 : 2) et sur la comparaison avec les plats tout prêts (item 4 inversé : 2). Levier : renforcer le sentiment d'efficacité personnelle par un atelier pratique avec une recette très simple et réussie (expérience de maîtrise), et faire goûter un plat maison comparé à un plat tout prêt.
4. La compréhension des items par le public (pré-test auprès de quelques parents) ; la cohérence interne de l'échelle (les items mesurent-ils la même chose ?) ; la stabilité des réponses ; l'absence d'item ambigu.

Corrigé – Exercice 3.45

1. Légumineuses : (0,4 − 1,8 + 2,1 − 1,2 − 0,9 + 1,6) / 6 = 0,2 / 6 = + 0,03. Pâtes : (1,9 + 2,3 + 2,0 + 0,8 + 0,6 + 1,4) / 6 = 9,0 / 6 = + 1,50.
2. Écarts (pâtes − légumineuses) : savoureux 1,9 − 0,4 = 1,5 ; rapide 2,3 − (− 1,8) = 4,1 ; bon marché 2,0 − 2,1 = − 0,1 ; digeste 0,8 − (− 1,2) = 2,0 ; moderne 0,6 − (− 0,9) = 1,5 ; rassasiant 1,4 − 1,6 = − 0,2. Les deux plus grands écarts : rapidité (4,1) et digestibilité (2,0).
3. Les légumineuses sont jugées bon marché (+ 2,1, autant que les pâtes) et rassasiantes (+ 1,6, plus que les pâtes) : ce sont deux arguments à mettre en avant.
4. Rapidité : montrer les solutions rapides (lentilles corail cuites en 15 minutes sans trempage, légumineuses en conserve rincées, cuisson en grande quantité et congélation). Digestibilité : expliquer le trempage, la cuisson complète, le rinçage des conserves, l'introduction progressive et les épices (cumin), et faire goûter des préparations douces (houmous, soupe).
5. L'outil décrit l'image de l'aliment sur plusieurs dimensions : il montre précisément quels freins lever (temps, digestion) et quels atouts utiliser, alors qu'une question globale donne seulement un « oui » ou un « non » sans orienter l'action.

Corrigé – Exercice 3.46

1. Transcrire les entretiens ; lire plusieurs fois ; découper le texte en unités de sens ; construire une grille de catégories (définies à l'avance ou issues du texte) ; classer chaque unité, de préférence à deux pour vérifier l'accord ; compter les fréquences ; interpréter en illustrant par des citations.
2. Prix : 34 / 120 × 100 = 28,3 % ; temps : 26 / 120 = 21,7 % ; goût des enfants : 22 / 120 = 18,3 % ; transport : 15 / 120 = 12,5 % ; savoir-faire : 14 / 120 = 11,7 % ; équipement : 9 / 120 = 7,5 % ; total 34 + 26 + 22 + 15

+ 14 + 9 = 120 unités, soit 100 %.

3. Capacité : savoir-faire (capacité psychologique), fatigue (capacité physique, liée au temps). Opportunité physique : prix, temps, transport, équipement. Opportunité sociale : goût des enfants (contexte familial). Motivation automatique : la peur de jeter et le découragement (« je jette ») relèvent aussi de la motivation.

4. Six entretiens seulement, avec des parents volontaires ; le nombre d'unités de sens dépend de la façon de parler de chacun (une personne bavarde pèse plus) ; une catégorie souvent citée n'est pas forcément la plus importante pour la personne ; l'entretien qualitatif sert à comprendre et à construire des hypothèses, pas à mesurer une fréquence dans une population. Il faudrait un questionnaire auprès d'un échantillon plus large pour quantifier.

Corrigé – Exercice 3.47

1. Avant : 42 / 120 = 35,0 % ; après : 63 / 115 = 54,8 % ; écart : 54,8 − 35,0 = 19,8 points.

2. Avant : erreur type = racine de (0,350 × 0,650 / 120) = 0,0435 ; marge = 1,96 × 0,0435 = 0,085, soit 8,5 points ; IC 95 % = [26,5 % ; 43,5 %]. Après : erreur type = racine de (0,548 × 0,452 / 115) = 0,0464 ; marge = 1,96 × 0,0464 = 0,091, soit 9,1 points ; IC 95 % = [45,7 % ; 63,9 %].

3. Les deux intervalles ne se chevauchent pas (43,5 % < 45,7 %) : la hausse est très probablement réelle et pas seulement due au hasard de l'échantillonnage. (Un chevauchement n'aurait pas suffi à conclure à l'absence de différence ; un test de comparaison de deux proportions est plus rigoureux.)

4. Non. Les personnes interrogées ne sont pas les mêmes (les participants assidus ont pu être davantage interrogés la seconde fois) ; d'autres facteurs ont pu jouer (hausse du prix de la viande, campagne nationale, saison) ; il n'y a pas de groupe de comparaison ; les réponses sont déclaratives et la désirabilité sociale peut augmenter après des ateliers.

5. Interroger les mêmes personnes avant et après (données appariées, avec un code anonyme) ; comparer avec un quartier sans ateliers (groupe témoin) ; mesurer aussi la participation de chaque personne aux ateliers (relation dose-effet) ; ajouter une mesure à distance (6 mois après la fin).

Corrigé – Exercice 3.48

1. Taux de réponse : 48 / 64 × 100 = 75,0 %. Grignotage la nuit : 31 / 48 × 100 = 64,6 %. Boissons sucrées ou énergisantes en intervention : 22 / 48 × 100 = 45,8 %. Repas en commun : 40 / 48 × 100 = 83,3 %. Stades : précontemplation 14 / 48 = 29,2 % ; contemplation 16 / 48 = 33,3 % ; préparation 10 / 48 = 20,8 % ; action 5 / 48 = 10,4 % ; maintien 3 / 48 = 6,3 % ; total 100,0 %. Plus de six sur dix (62,5 %) ne sont pas encore prêts à agir.

2. Identité professionnelle et appartenance : la « popote » est un rite qui construit l'équipe ; toucher aux repas, c'est toucher à l'identité du groupe (« la popote, c'est sacré », « c'est ce qui fait l'équipe »). Normes : la norme descriptive et injonctive est « on mange gras et sucré, c'est la tradition » (4,1 sur 5) ; manger léger est sanctionné par la moquerie (« on le chambre »). Conformisme : dans un groupe très soudé, s'écarter de la norme est coûteux ; chacun suit le groupe. Alimentation émotionnelle : après une intervention difficile, le sucre sert à « décompresser » ; c'est une régulation du stress. À cela s'ajoutent l'environnement (distributeur, gâteaux apportés la nuit) et le travail de nuit, qui perturbe la faim et la satiété.

3. Attitude très favorable (4,3) : les pompiers savent que l'alimentation compte pour leur condition physique ; un message d'information est inutile. Norme subjective défavorable (tradition à 4,1 ; exemple du chef à 2,0). Contrôle perçu faible (2,4) : la nuit, l'offre disponible ne permet pas de manger équilibré. Leviers : la norme (s'appuyer sur des leaders d'opinion, le chef de centre, et sur l'identité « pompier en forme ») et le contrôle perçu (changer l'offre de nuit), sans jamais parler de régime.

4. Objectif général : d'ici fin 2027, améliorer l'alimentation pendant les gardes de nuit des sapeurs-pompiers du centre de Saint-Avit pour soutenir leur condition physique et leur vigilance. Objectifs spécifiques : réduire de 64,6 % à 45 % la part des pompiers qui grignotent au moins trois fois par garde de nuit ; faire

passer de 2,4 à 3,5 le score moyen de l'item « je peux manger équilibré pendant les gardes de nuit ». Objectifs opérationnels : mettre en place, avant mars 2027, une collation de nuit préparée à la popote pour chaque garde (indicateur : nombre de gardes avec collation, cahier de la popote) ; organiser deux ateliers « popote de garde » avec les cuisiniers volontaires avant juin 2027 (feuilles de présence) ; obtenir que le chef de centre et deux chefs d'agrès présentent le projet lors du rapport de garde avant février 2027 (compte rendu).

5. Action 1 : « collation de garde » préparée la veille à la popote (pain complet, fromage, fruits, soupe, œufs durs) et rangée dans un réfrigérateur dédié : restructuration de l'environnement, contrôle perçu ; utile à tous les stades. Action 2 : ateliers « popote de garde » animés avec les pompiers cuisiniers, qui revisitent les plats traditionnels (même plaisir, moins gras) : identité respectée, expérience de maîtrise, efficacité personnelle ; pour les stades de contemplation et de préparation. Action 3 : le chef de centre et des pompiers reconnus (sportifs, anciens) montrent l'exemple et en parlent au rapport : modélisation, norme injonctive et descriptive, influence des leaders. Action 4 : défi d'équipe volontaire « garde sans distributeur » pendant un mois, avec un tableau des équipes participantes : engagement libre et public, cohésion du groupe mise au service du changement ; pour les stades de préparation et d'action. Pour la précontemplation : aucune pression, informations courtes et concrètes sur le sommeil, la vigilance et la condition physique, et accès à la collation comme tout le monde.

6. Budget : collations de nuit pour un test de 3 mois : 13 semaines × 7 nuits × 6 pompiers de garde × 0,80 € = 436,80 € ; deux ateliers « popote de garde » (denrées et intervention) : 2 × 150,00 € = 300,00 € ; boîtes et gourdes : 64 × 4,50 € = 288,00 € ; affiches et supports : 80,00 € ; sous-total 436,80 + 300,00 + 288,00 + 80,00 = 1 104,80 € ; imprévus : 1 200 − 1 104,80 = 95,20 € (7,9 %) ; total 1 200,00 €.

7. Processus : nombre de gardes avec collation, nombre de participants aux ateliers, nombre d'équipes engagées dans le défi, consommation du distributeur la nuit (relevé des ventes), respect du budget. Résultats : même questionnaire anonyme à un an (part des grignoteurs, stades, scores de Likert) ; satisfaction ; entretiens de groupe sur la popote. Impact à plus long terme : résultats collectifs et anonymes aux tests de condition physique, suivis par le médecin-chef, en restant prudent (beaucoup d'autres facteurs agissent).

8. Les données de santé (poids, résultats médicaux) restent sous la responsabilité du service de santé et sont couvertes par le secret médical ; elles ne sont jamais transmises à la hiérarchie opérationnelle ; le questionnaire reste anonyme et les résultats ne sont présentés que de façon collective ; aucune participation n'est obligatoire et aucune sanction ou notation n'est liée au projet ; les résultats aux tests physiques ne servent pas à classer les pompiers. Communication : parler de « popote de garde », de vigilance et de condition physique, jamais de régime ou de poids ; associer les cuisiniers et les leaders d'opinion ; valoriser les réussites de l'équipe ; photos uniquement avec accord, sans données de santé.

Bilan : grille d'auto-évaluation

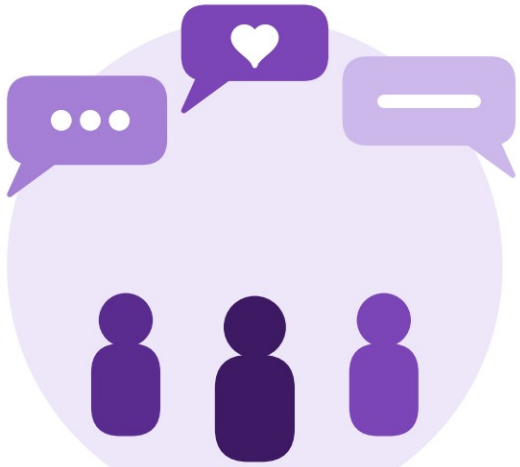
Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Distinguer les regards disciplinaires ; expliquer le paradoxe de l'omnivore, l'incorporation, l'espace social alimentaire, la socialisation et l'identité	3.1 à 3.6			
2	Définir une représentation sociale ; réaliser une analyse prototypique et une mise en cause ; distinguer normes descriptives et injonctives ; analyser une situation interculturelle	3.7 à 3.12			
3	Présenter les expériences d'influence sociale ; utiliser la dissonance et l'engagement de façon éthique ; prévenir la stigmatisation ; coter une échelle d'attitude	3.13 à 3.18			
4	Classer les 9 CPS ; concevoir une séance SAFE ; coter une échelle d'estime de soi ; analyser des silhouettes ; distinguer faim physiologique et émotionnelle	3.19 à 3.24			
5	Utiliser les stades du changement, la théorie du comportement planifié, les croyances relatives à la santé, l'efficacité personnelle et COM-B	3.25 à 3.30			
6	Repérer les bruits de la communication ; reconnaître les attitudes de Porter ; reformuler ; appliquer l'entretien motivationnel ; construire une balance décisionnelle	3.31 à 3.36			
7	Reconnaître les étapes, les rôles et les styles d'animation ; choisir une technique ; situer une motivation ; utiliser un nudge de façon éthique	3.37 à 3.42			
8	Construire et coter une échelle ; utiliser un différenciateur sémantique ; faire une analyse de contenu ; comparer deux proportions ; traiter un cas complet	3.43 à 3.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5



CHAPITRE

03

Éléments de psychologie sociale

Psychologie | Sociologie | Anthropologie de l'alimentation

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 3 223
Mode d'emploi du cahier d'annales 223
Ce que le jury attend sur ce chapitre 223
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 224
S1 – « Un vrai casse-croûte de chantier » : représentations et habitudes alimentaires des apprentis d'un CFA du bâtiment 224
S2 – « Les hommes aux fourneaux » : un atelier pour des hommes âgés qui vivent seuls 228
S3 – Vers l'autonomie : des jeunes de la protection de l'enfance qui apprennent à se nourrir seuls 231
Partie II – Les corrigés détaillés 234
Corrigé S1 – « Un vrai casse-croûte de chantier » : les apprentis d'un CFA du bâtiment 234
Corrigé S2 – « Les hommes aux fourneaux » : un atelier pour des hommes âgés qui vivent seuls 241
Corrigé S3 – Vers l'autonomie : des jeunes de la protection de l'enfance 246
Grille d'auto-évaluation 252

Cahier d'annales E5 – chapitre 3

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes et les données des enquêtes sont fictives : elles sont construites pour l'entraînement et ne doivent pas être citées comme des données réelles. Les données nationales et les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Un vrai casse-croûte de chantier » : représentations et habitudes alimentaires des apprentis d'un CFA du bâtiment	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Les hommes aux fourneaux » : un atelier pour des hommes âgés qui vivent seuls	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	Vers l'autonomie : des jeunes de la protection de l'enfance qui apprennent à se nourrir seuls	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 3 donne les outils pour comprendre le mangeur et le groupe : représentations sociales, normes, identité et socialisation, influence sociale, attitudes et dissonance, stéréotypes et stigmatisation, compétences psychosociales, modèles du changement de comportement (Prochaska et DiClemente, Ajzen, Bandura, COM-B, autodétermination), écoute et animation de groupe. Le jury vérifie que le candidat sait **recueillir** les représentations et les attitudes d'un public (évocation hiérarchisée, échelle de Likert), **analyser** les résultats avec rigueur, puis **choisir des leviers** cohérents avec ce diagnostic : agir sur les normes et l'environnement plutôt que culpabiliser, renforcer le sentiment d'efficacité personnelle, respecter l'autonomie des personnes et ne jamais stigmatiser.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; surligner le public, ses représentations (citations), les chiffres, les contraintes et le verbe de chaque consigne. Pendant : pour chaque résultat d'enquête, écrire le calcul, le résultat et une phrase d'interprétation qui nomme un concept de psychologie sociale (norme, représentation, efficacité personnelle, stade de changement) et le levier qui en découle. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Un vrai casse-croûte de chantier » : représentations et habitudes alimentaires des apprentis d'un CFA du bâtiment

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II).

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année au centre de formation d'apprentis (CFA) du bâtiment et des travaux publics de Vauclair (structure fictive). Le CFA accueille 640 apprentis de 16 à 25 ans (maçonnerie, couverture, plomberie, électricité, menuiserie, peinture) ; 94 % sont des garçons. Les apprentis alternent deux semaines en entreprise et une semaine au CFA. L'infirmière du CFA vous confie une demande : « Plusieurs jeunes ont fait des malaises sur les chantiers en début de matinée. Beaucoup partent à 6 heures sans rien avaler et tiennent avec une boisson énergisante. Au self, ils prennent des frites et laissent les légumes. Quand l'un d'eux prend une salade, les autres se moquent. Les messages du type "mangez cinq fruits et légumes" ne marchent pas du tout avec eux. » Vous devez comprendre ce public, concevoir un projet, en réaliser une partie pendant votre stage et en rendre compte dans votre dossier E5.

Document 1 – La structure, le public et les moyens

- Équipe : une infirmière à temps plein, une conseillère principale d'éducation, une référente handicap, 42 formateurs ; un self de 220 places géré par une société de restauration collective (menu à 4,10 € pour l'apprenti) ; un foyer de jeunes travailleurs voisin qui loge 56 apprentis.
- Public : apprentis de 16 à 25 ans, rémunérés en pourcentage du SMIC selon l'âge et l'année de formation ; journées de chantier de 7 h 30 à 16 h 30, avec un départ souvent avant 6 h 30 en camionnette ; repas de midi pris sur le chantier, dans le véhicule ou dans une boulangerie.
- Partenaires possibles : maîtres d'apprentissage (entreprises), service de prévention de l'organisme professionnel du BTP, mission locale, maison des adolescents, société de restauration du self, association sportive du CFA.
- Budget : 1 700 € accordés par le fonds régional de prévention pour l'année scolaire, matériel compris.

Document 2 – Recueil des représentations par évocation hiérarchisée (données fictives)

Consigne donnée à 160 apprentis : « Écrivez les cinq premiers mots qui vous viennent à l'esprit quand on vous dit "bien manger", puis numérotez-les du plus important (1) au moins important (5). » Les réponses ont été regroupées en catégories. Le tableau donne, pour les dix catégories les plus citées, le nombre de citations et le rang moyen d'importance.

Catégorie	Nombre de citations	Rang moyen d'importance (1 à 5)
Viande	92	2,1
Manger beaucoup, être calé	78	2,4
Légumes	70	3,6
Force	64	2,8

Catégorie	Nombre de citations	Rang moyen d'importance (1 à 5)
Plaisir	58	2,7
Sport, muscles	44	3,2
Régime, faire attention	41	3,9
Maman, repas de famille	38	2,2
Cher	30	3,8
Fast-food	26	2,6

Pour l'analyse prototypique (méthode de Vergès, 1992), on retient comme seuil de fréquence la moyenne des citations des dix catégories et comme seuil d'importance la moyenne des rangs moyens.

Document 3 – Questionnaire et échelles d'attitude (données fictives, 160 répondants sur 640 apprentis)

Question	Nombre de « oui » (n = 160)
Ne prend rien à manger avant de partir, les jours de chantier	98
Boit au moins une boisson énergisante par jour	54
Déjeune au self du CFA pendant les semaines de formation	46
Mange un sandwich ou un repas de restauration rapide le midi, au moins 3 jours de chantier sur 5	88
Mange des fruits ou des légumes chaque jour	37
A déjà entendu une moquerie sur ce qu'il mange, au CFA ou sur le chantier	61

Stade de changement pour « prendre quelque chose à manger avant de partir sur le chantier » : précontemplation 72 ; contemplation 40 ; préparation 22 ; action 16 ; maintien 10.

Échelle de Likert construite selon la théorie du comportement planifié (1 = pas du tout d'accord ; 5 = tout à fait d'accord) : moyenne des 160 réponses.

Item	Dimension	Sens	Moyenne
A1 – Manger avant de partir m'aide à tenir sur le chantier	Attitude	positif	3,8
A2 – Le petit-déjeuner, c'est une perte de temps	Attitude	négatif	3,1
N1 – Mon maître d'apprentissage pense que je devrais manger avant de partir	Norme subjective	positif	2,4
N2 – Mes collègues de chantier mangent avant de partir	Norme descriptive	positif	2,1
C1 – Je peux facilement manger quelque chose avant de partir à 6 heures	Contrôle perçu	positif	2,0
C2 – Le matin, je n'ai rien à manger chez moi	Contrôle perçu	négatif	3,4
I1 – J'ai l'intention de manger avant de partir la semaine prochaine	Intention	positif	2,6

Croisement selon le logement : parmi les 104 apprentis qui vivent chez leurs parents, 56 ne prennent rien avant de partir ; parmi les 56 qui vivent seuls ou au foyer de jeunes travailleurs, 42 ne prennent rien.

Document 4 – Ce qu'ils disent (entretiens collectifs, deux groupes de 8 apprentis)

« Sur le chantier, celui qui mange une salade, on l'appelle "la chèvre". » (Enzo, 17 ans, maçon)

« Un vrai repas, c'est de la viande et des frites. Le reste, c'est pour les filles. » (Bilal, 18 ans, couvreur)

« Le matin à 5 h 45, j'ai pas faim. Je prends un energy dans la camionnette, ça réveille. » (Théo, 16 ans, électricien)

« Mon patron, lui, il mange rien jusqu'à midi. Il dit que ça coupe les jambes. » (Kylian, 19 ans, plombier)

« Chez ma mère, on mange bien, avec des légumes. Depuis que je suis au foyer, c'est kebab. » (Mathis, 20 ans, menuisier)

« Si c'est pour nous dire qu'on mange mal, on connaît, on a eu ça au collège. » (Yanis, 17 ans, peintre)

« Moi je veux prendre du muscle. Je regarde des vidéos sur l'alimentation des sportifs. » (Lucas, 18 ans, maçon)

Document 5 – Deux propositions reçues par l'équipe du CFA

Un formateur propose de « motiver les jeunes » en les pesant tous en début de séance, puis en publiant chaque mois sur le groupe de messagerie de la classe un classement « des kilos perdus et gagnés ». Une semaine plus tard, une courte vidéo circule sur un réseau social : un apprenti en situation d'obésité y est filmé au self, à son insu, avec des commentaires moqueurs. Enfin, la direction vous demande de réaliser pour la page publique du CFA une vidéo du projet « avec les visages des jeunes, pour que ça fasse vrai ».

Document 6 – Données nationales et cadre des politiques publiques (données réelles)

- L'ANSES (avis du 1er octobre 2013 sur les boissons dites « énergisantes ») recommande d'éviter leur consommation en association avec l'alcool et lors d'un exercice physique, et de la limiter chez les enfants et les adolescents.
- Santé publique France a publié en 2022 un référentiel des compétences psychosociales (CPS) : 9 CPS générales réparties en trois catégories (cognitives, émotionnelles, sociales).
- L'instruction interministérielle du 19 août 2022 fixe une stratégie nationale de développement des CPS chez les enfants et les jeunes pour la période 2022-2037.
- Le programme national nutrition santé 2026-2030 (PNNS 5) a été lancé le 8 avril 2026 ; la réduction des inégalités sociales de santé en nutrition en est une priorité.
- La stigmatisation liée au poids est fréquente à l'école, au travail et dans les soins ; elle nuit à la santé psychologique et favorise des comportements défavorables, comme l'évitement de l'activité physique et des soins (Puhl et Heuer, « The stigma of obesity: a review and update », Obesity, 2009).

Travail à faire

Partie A – Le projet d'intervention (dossier écrit de 10 pages au plus) – C3.1 (9 points)

1. Réalisez l'analyse prototypique du document 2 : calculez les deux seuils, classez les dix catégories dans un tableau à quatre cases, puis interprétez la représentation du « bien manger » des apprentis (noyau central, éléments périphériques, zone contrastée). Indiquez ce que cette analyse change pour vos messages. (2 pts)
2. Calculez les indicateurs du document 3 (pourcentages, taux de participation, répartition par stade de changement) et posez le diagnostic ; formulez le problème central. (1,5 pt)
3. Calculez le score de chaque dimension de l'échelle de Likert (en inversant les items négatifs) et interprétez-les avec la théorie du comportement planifié d'Ajzen (1991). Quels leviers en déduisez-vous ? (1,5 pt)
4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et des objectifs opérationnels, chacun avec un indicateur, une valeur cible et une échéance. (1,5 pt)
5. Présentez le plan d'action sur l'année scolaire en justifiant chaque action par un concept de psychologie sociale (normes sociales, influence des pairs, engagement, sentiment d'efficacité personnelle, compétences psychosociales) et un budget qui respecte les 1 700 €. (1,5 pt)
6. Construisez la démarche d'évaluation (processus, résultats) et proposez la valorisation du projet. (1 pt)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée – C3.3 (3 points)

7. Calculez le risque relatif de ne rien manger avant de partir selon le logement (document 3) et interprétez-le. Peut-on conclure que vivre seul est la cause de ce comportement ? (1,5 pt)

8. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion d'apprentis qui ne mangent rien avant de partir, puis la taille d'échantillon nécessaire pour une précision de ± 5 points (avec correction pour une population de 640). Présentez trois limites de l'évocation hiérarchisée et de l'échelle de Likert. (1,5 pt)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

9. Organisez une veille sur les interventions psychosociales en nutrition auprès des jeunes et sur l'alimentation des travailleurs du bâtiment : sources fiables, outils, fréquence, diffusion. (2 pts)

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique – C3.5 et C3.6 (3 points)

10. Analysez les trois situations du document 5 (stigmatisation, cyberharcèlement, droit à l'image et données de santé) et rédigez la réponse que vous proposez à la direction du CFA. (1,5 pt)

11. Proposez des supports de communication adaptés à ces jeunes (sans moralisation) ; rédigez la trame minutée de votre exposé de 10 minutes et listez 15 questions probables du jury. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Les hommes aux fourneaux » : un atelier pour des hommes âgés qui vivent seuls

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des sujets U62 et E5.B (bon de commande, fiche technique, organisation dans le temps, hygiène) et du BTS blanc CNED E5B (adaptation d'une recette et calcul nutritionnel).

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Le centre communal d'action sociale (CCAS) de Belcourt-sur-Loire (structure fictive) a repéré, grâce au service de portage de repas et aux médecins généralistes, des hommes de plus de 65 ans qui vivent seuls depuis peu, le plus souvent après le décès de leur épouse. Beaucoup n'ont « jamais fait la cuisine » ; ils mangent des plats tout prêts, du pain et du fromage, ou sautent le repas du soir. Deux d'entre eux ont perdu plus de 5 % de leur poids en six mois. Les hommes refusent les ateliers « nutrition » existants (« c'est plein de dames, je n'ose pas »). Le CCAS vous demande de concevoir et d'animer le premier atelier d'un cycle de six séances baptisé « Les hommes aux fourneaux », réservé aux hommes, dans la cuisine du foyer-restaurant municipal.

Document 1 – Le public et les contraintes

- 8 hommes de 66 à 84 ans, veufs ou séparés, vivant seuls à domicile ; anciens ouvriers, artisans, agriculteurs ou employés.
- Monsieur R. (79 ans) a un diabète de type 2 traité par comprimés ; Monsieur P. (84 ans) porte un appareil dentaire et a du mal à mâcher les aliments durs ; Monsieur L. (72 ans) suit un régime pauvre en sel pour une insuffisance cardiaque ; Monsieur D. (68 ans) dit en riant : « Moi, je ne sais même pas faire cuire un œuf. »
- Plusieurs participants ont des difficultés de vue ou d'audition ; deux se déplacent avec une canne.
- Cuisine du foyer-restaurant : 4 plaques, 2 fours, 1 four à micro-ondes, 1 réfrigérateur, 4 postes de travail pour 2 personnes, tables à hauteur réglable.
- Budget denrées : au plus 3,00 € par portion ; 10 portions (8 participants et 2 professionnels).
- Durée de l'atelier avec le public : 2 h 30, de 9 h 30 à 12 h 00, repas compris. Le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 2 – Menu imposé

Plat : papillote de lieu noir aux poireaux, à la crème et au citron ; pommes de terre vapeur.

Dessert : crumble pommes-poires aux flocons d'avoine.

Le candidat réalise le plat et le dessert. Il présente aussi les adaptations pour Monsieur R. (diabète), Monsieur P. (mastication) et Monsieur L. (sel), et une version « pour un » que chaque participant pourra refaire chez lui.

Document 3 – Grammages nets par portion, pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Grammage net par portion	Perte au parage ou à l'épluchage	Prix
Filet de lieu noir, frais, sans peau ni arêtes	120 g	sans perte	12,90 € le kg
Poireaux	100 g	30 %	2,20 € le kg

Denrée	Grammage net par portion	Perte au parage ou à l'épluchage	Prix
Pommes de terre	200 g	20 %	1,20 € le kg
Crème légère 15 % MG, fluide	15 g	sans perte	3,40 € le kg
Citron	10 g	40 %	3,00 € le kg
Pommes	60 g	20 %	2,40 € le kg
Poires	60 g	20 %	2,80 € le kg
Flocons d'avoine	15 g	sans perte	2,00 € le kg
Farine de blé T55	10 g	sans perte	1,10 € le kg
Beurre doux	8 g	sans perte	9,50 € le kg
Sucre blanc	6 g	sans perte	1,30 € le kg
Papier sulfurisé, aneth, poivre, cannelle	–	–	forfait 0,80 € pour l'atelier

Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte).

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Vitamine D (µg)
Lieu noir, cru	82,5	18,8	0	0,8	0	0,2	1,77
Poireau, cru	30,4	1,5	4,55	0,3	1,8	0,05	0
Pomme de terre, sans peau, crue	80	2,02	16,2	0,09	2,2	< 0,0011	0
Crème 12 à 20 % MG, légère, fluide, rayon frais	173	2,96	4,3	16	0	0,15	–
Citron, chair sans peau, sans pépins, cru	24,3	0,25	1,56	< 0,5	< 0,5	< 0,013	0
Pomme, chair sans peau, crue (aliment moyen)	51,3	0,26	11,9	0,24	2,39	0,0064	–
Poire, chair, crue (aliment moyen)	49,7	0,25	11,4	< 0,5	3,1	< 0,013	–
Flocons d'avoine	369	10,6	57,7	7,82	11,2	0,011	0
Farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains)	350	9,03	73,7	1	3,2	< 0,13	< 0,25
Beurre à 80 % MG minimum, doux	753	0,64	0,71	83	0	0,035	< 1
Sucre blanc	399	0	99,7	0	0	0,0054	0

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < » ou « – » (non disponible) est comptée 0. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (fichier du 3 novembre 2025, mis en ligne le 19 novembre 2025).

Document 5 – Repères utiles (données réelles)

- Besoin en protéines estimé à environ 1,0 g par kg de poids et par jour chez la personne âgée (AFSSA, rapport « Apport en protéines : consommation, qualité, besoins et recommandations », 2007).
- Apport satisfaisant en vitamine D : 15 µg par jour chez l'adulte (ANSES, références nutritionnelles, 2021) ; 30 g de fibres par jour chez l'adulte.
- Apport en sel : moins de 5 g par jour pour un adulte (OMS, 2012).
- Une perte de poids d'au moins 5 % en un mois ou d'au moins 10 % en six mois est un critère phénotypique de dénutrition chez la personne de 70 ans et plus (HAS, recommandation de novembre 2021).
- Sentiment d'efficacité personnelle : croyance d'une personne en sa capacité à réaliser une action ; il se renforce surtout par les expériences de réussite (Bandura, 1977).

Travail à faire

Partie 1 – Conception (11 points)

1. Identifiez les besoins de ce public (nutritionnels, psychologiques et sociaux) et formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier. (2 pts)

2. Établissez le bon de commande pour 10 portions (quantités nettes, quantités brutes, unités de commande, coût) ; calculez le coût par portion et vérifiez le respect du budget. (2 pts)

3. Rédigez la fiche technique de la papillote (ingrédients, matériel, étapes, points critiques) et la fiche « pour un » simplifiée ; présentez les adaptations pour Monsieur R., Monsieur P. et Monsieur L. (3 pts)

4. Calculez l'apport d'une portion du plat et du repas complet (énergie, protéines, glucides, lipides, fibres, sel, vitamine D) et la répartition de l'énergie ; calculez la part du besoin en protéines couverte pour un homme de 75 kg ; commentez au regard du risque de dénutrition. (2 pts)

5. Expliquez, avec les notions de psychologie sociale du chapitre (identité et rôles de genre, sentiment d'efficacité personnelle, isolement, motivation), pourquoi ces hommes ne cuisinent pas et comment l'atelier peut les aider ; montrez les limites d'un atelier isolé. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et participants), en tenant compte de la vue, de l'audition et de la mobilité des participants. (2 pts)

7. Présentez les méthodes d'animation qui renforcent le sentiment d'efficacité personnelle, les outils (fiche recette en gros caractères, photos des étapes) et une grille de dégustation adaptée. (1,5 pt)

8. Présentez les règles d'hygiène (5 M, poisson, cuisson, conservation des restes à domicile), les allergènes et trois éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

9. Réalisez la papillote, les pommes de terre vapeur et le crumble ; dressez deux assiettes, dont une adaptée à Monsieur P. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier (satisfaction, acquis, sentiment de compétence, intention de refaire). (1 pt)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Vers l'autonomie : des jeunes de la protection de l'enfance qui apprennent à se nourrir seuls

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet mixte – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) sur une même situation

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : 30 min d'oral préparé (temps 1) et 3 h (temps 2) · Barème : 20 points par temps.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique au service d'accompagnement vers l'autonomie « Les Passerelles » de la ville de Maurepont (structure fictive), rattaché à une maison d'enfants à caractère social. Le service accompagne 24 jeunes de 16 à 20 ans confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) : les mineurs et les jeunes majeurs sous contrat d'accompagnement vivent seuls ou à deux dans des studios répartis dans la ville. Chaque jeune reçoit du service une allocation pour son alimentation et gère ses courses. Les éducateurs constatent que beaucoup de jeunes « vivent de livraisons et de pâtes au ketchup », sautent des repas et n'ont plus d'argent à la fin du mois. Lors de la réunion des jeunes, plusieurs ont dit : « On ne nous a jamais appris, au foyer tout était fait. » La cheffe de service vous confie un projet « Se nourrir seul, c'est possible ».

Document 1 – Données réelles sur les jeunes de la protection de l'enfance

- La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants renforce l'accompagnement des jeunes majeurs de moins de 21 ans sortant de l'ASE qui n'ont pas de ressources ou de soutien familial suffisants.
- Dans l'enquête Sans-domicile 2012 (Insee et Ined), 23 % des personnes sans domicile nées en France avaient été placées dans leur enfance (Frechon et Marpsat, Économie et statistique n° 488-489, 2016).
- Santé publique France (2022) range parmi les compétences psychosociales sociales la capacité à « développer des relations constructives » et parmi les compétences cognitives la capacité à « prendre des décisions constructives » ; leur développement fait partie de la stratégie nationale 2022-2037.
- Selon la théorie de l'autodétermination (Deci et Ryan, 1985, révisée en 2000), la motivation durable repose sur la satisfaction de trois besoins : autonomie, compétence et appartenance sociale.

Document 2 – Enquête menée au service (données fictives)

22 jeunes sur 24 ont répondu à un questionnaire anonyme rempli sur tablette pendant un temps collectif, avec l'aide d'une éducatrice pour la lecture si besoin.

Question	Nombre de « oui » (n = 22)
Saute au moins un repas par jour, au moins 4 jours sur 7	13
Mange un plat préparé, une livraison ou un repas de restauration rapide au moins 4 fois par semaine	15
Sait cuisiner au moins 3 plats sans aide	6
Fait ses courses avec une liste	4
N'a plus eu d'argent pour manger avant la fin du mois, au moins une fois dans les 3 derniers mois	12
Souhaite apprendre à cuisiner	17

Échelle de sentiment d'efficacité personnelle (« Je me sens capable de… », 1 = pas du tout capable ; 5 = tout à fait capable), moyenne des 22 réponses : préparer un repas complet : 2,1 ; faire mes courses de la semaine avec 30 € : 2,4 ; cuisiner pour des amis : 1,9 ; lire une étiquette et comparer deux produits : 3,0 ; conserver et

réutiliser des restes : 2,2 ; préparer un repas quand je suis fatigué au lieu de commander : 2,6.

Document 3 – Moyens et contraintes

Budget accordé par le département au titre des actions collectives : 900 € pour l'année. Cuisine collective du service : 4 plaques, 1 four, 1 four à micro-ondes, 2 réfrigérateurs, 1 congélateur, 4 postes de travail. Contraintes signalées par les éducateurs : horaires décalés (lycée professionnel, apprentissage, emploi de nuit pour deux jeunes) ; méfiance envers « les adultes qui décident pour nous » ; histoires familiales difficiles, pour lesquelles le repas peut réveiller des souvenirs douloureux ; usage intensif des réseaux sociaux ; petits studios avec deux plaques, un four à micro-ondes et un réfrigérateur avec un petit compartiment congélateur.

Travail à faire – Temps 1

1. Calculez les indicateurs de l'enquête, le taux de réponse et le score moyen d'efficacité personnelle ; repérez les deux capacités les plus faibles et la plus forte ; présentez les limites de ces données. (4 pts)
2. Analysez la situation avec les notions de psychologie sociale : socialisation primaire et secondaire, identité, compétences psychosociales, théorie de l'autodétermination ; montrez en quoi ces jeunes sont exposés à une inégalité sociale de santé. (3 pts)
3. Formulez les objectifs (général, spécifiques, opérationnels) et le plan d'action sur 12 mois, en associant les jeunes aux décisions. (5 pts)
4. Présentez la démarche d'évaluation et un budget qui respecte les 900 €. (3 pts)
5. Indiquez les précautions éthiques et juridiques : données personnelles, secret professionnel, photos et réseaux sociaux, sujets sensibles (histoire familiale). (3 pts)
6. Expression et sources. (2 pts)

Travail à faire – Temps 2

Document 4 – Atelier imposé et données (prix construits pour le sujet ; composition : table Ciqual 2025, ANSES, 19 novembre 2025)

Atelier « Cuisiner une fois, manger quatre fois » de 2 h, de 17 h 30 à 19 h 30, pour 8 jeunes (dont une jeune fille végétarienne qui mange des œufs et des produits laitiers, et deux jeunes qui ne mangent que de la viande halal), suivi du repas pris ensemble. Coût des denrées : au plus 2,00 € par portion ; 10 portions (8 jeunes et 2 professionnels). Chaque jeune repart avec une portion congelée.

Menu : chili doux au bœuf et aux haricots rouges, riz blanc ; salade d'oranges à la cannelle.

Grammages nets par portion : bœuf haché 5 % MG 60 g ; haricots rouges en conserve, égouttés 80 g ; oignon 20 g (10 % de perte) ; poivron 40 g (20 % de perte) ; tomates pelées au jus en conserve 80 g ; huile de colza 5 g ; riz blanc 60 g (cru) ; orange 150 g (30 % de perte).

Prix : bœuf haché 5 % MG (halal) 11,50 € le kg ; haricots rouges égouttés 2,40 € le kg ; oignons 1,80 € le kg ; poivrons 3,50 € le kg ; tomates pelées 2,20 € le kg ; huile de colza 3,20 € le litre (1 L = 920 g) ; riz 1,80 € le kg ; oranges 2,20 € le kg ; ail, cumin, paprika doux, cannelle : forfait 0,80 € pour l'atelier.

Aliment (libellé Ciqual 2025), pour 100 g	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)
Boeuf, steak haché 5% MG cru	130	21,9	0,3	4,59	0	0,097	2,65
Haricot rouge, appertisé, égoutté	108	8,31	13	0,97	7	0,68	1,5
Oignon, cru	39	1,1	6,25	0,62	1,7	0,098	0,00019

Aliment (libellé Ciqual 2025), pour 100 g	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)
Poivron, vert, jaune ou rouge, cru	22,6	0,8	3,5	0,27	1,5	0,021	0,4
Tomate, pelée, appertisée, au jus, non égouttée	21,8	0,79	3,15	0,25	1,9	0,025	0,57
Huile de colza	900	0	0	100	0	< 0,0028	0,023
Riz blanc, cru	350	7,02	77,5	0,79	1,53	0,0079	1,94
Orange, chair sans peau, sans pépins, crue	42	0,75	8,03	< 0,5	2,7	< 0,013	0,57

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < » est comptée 0. Repères (ANSES, 2021) : fer 11 mg par jour pour une femme adulte ayant des pertes menstruelles faibles à normales ; fibres 30 g par jour.

7. Identifiez les besoins et les objectifs de l'atelier ; justifiez le choix du menu au regard du public (budget, équipement des studios, horaires, autonomie, convictions). (3 pts)

8. Établissez le bon de commande pour 10 portions et la fiche technique du chili ; calculez l'apport du repas complet (énergie, protéines, glucides, lipides, fibres, sel, fer) et la répartition de l'énergie ; proposez la version végétarienne et calculez sa teneur en protéines. (5 pts)

9. Présentez le déroulé de l'atelier, les techniques d'animation qui respectent l'autonomie des jeunes et la grille de dégustation. (4 pts)

10. Présentez les règles d'hygiène (viande hachée, refroidissement rapide, congélation et décongélation, allergènes) et les éco-gestes. (4 pts)

11. Réalisez les préparations, conditionnez les portions à emporter et évaluez l'atelier. (4 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Un vrai casse-croûte de chantier » : les apprentis d'un CFA du bâtiment

que le jury attend

Le jury évalue la capacité à comprendre un public avant d'agir : recueillir et analyser ses représentations et ses attitudes, puis choisir des leviers cohérents avec ce diagnostic. Il valorise les calculs exacts et interprétés, l'usage juste des concepts (noyau central, norme descriptive, contrôle perçu, efficacité personnelle) et un projet qui s'appuie sur l'identité professionnelle des apprentis. Il pénalise la moralisation (« ils mangent mal »), les messages qui attaquent de front la représentation des jeunes et toute action qui expose un apprenti à la moquerie.

Partie A – Le projet d'intervention

Question 1 – Analyse prototypique de l'évocation hiérarchisée (2 pts)

Calcul posé – Les deux seuils

- Total des citations des dix catégories : 92 + 78 + 70 + 64 + 58 + 44 + 41 + 38 + 30 + 26 = **541**.
- Seuil de fréquence = 541 / 10 = **54,1 citations**.
- Somme des rangs moyens : 2,1 + 2,4 + 3,6 + 2,8 + 2,7 + 3,2 + 3,9 + 2,2 + 3,8 + 2,6 = 29,3.
- Seuil d'importance = 29,3 / 10 = **2,93**. Un rang moyen inférieur à 2,93 signifie que le mot est cité parmi les plus importants.

	Rang moyen inférieur à 2,93 (jugé important)	Rang moyen supérieur ou égal à 2,93 (jugé moins important)
Fréquence supérieure ou égale à 54,1	**Zone du noyau central** : viande (92 ; 2,1), manger beaucoup, être calé (78 ; 2,4), force (64 ; 2,8), plaisir (58 ; 2,7)	**Première périphérie** : légumes (70 ; 3,6)
Fréquence inférieure à 54,1	**Zone contrastée** : maman, repas de famille (38 ; 2,2), fast-food (26 ; 2,6)	**Seconde périphérie** : sport, muscles (44 ; 3,2), régime, faire attention (41 ; 3,9), cher (30 ; 3,8)

Interprétation. Selon la théorie du noyau central (Abric, 1994), le **noyau** donne son sens à la représentation ; il est stable, partagé et résiste au changement. Pour ces apprentis, « bien manger », c'est d'abord **manger copieux, de la viande, pour avoir de la force, avec plaisir** : une représentation liée à l'**identité professionnelle** d'un métier physique et à des **normes de genre** (document 4 : « le reste, c'est pour les filles »). Les **légumes** sont souvent cités (43,8 % des répondants : 70 / 160 × 100) mais à un rang tardif : ils sont connus comme une norme apprise (« on a eu ça au collège »), sans être au cœur du sens. La **seconde périphérie** associe le « bien manger » à la contrainte (régime) et au coût. La **zone contrastée** révèle des sous-groupes : pour certains, le bien manger est un **repas de famille** (souvent perdu en quittant le domicile, comme pour Mathis) ; pour d'autres, c'est la restauration rapide.

Conséquences pour les messages : ne pas attaquer le noyau (« mangez moins de viande », « 5 fruits et légumes ») ; **s'appuyer sur le noyau** pour y rattacher les éléments périphériques : « tenir jusqu'à midi sur le chantier », « le carburant du matin », « un casse-croûte qui cale et qui donne de la force » ; présenter les légumes et le petit-déjeuner comme des alliés de la force et du plaisir, jamais comme une privation. La périphérie est la partie de la représentation qui change le plus facilement : c'est là que le projet peut agir.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Classer les mots seulement selon leur fréquence ; oublier que le rang le plus important est le rang 1 (un rang moyen faible signifie une grande importance) ; parler de « noyau central » sans vérifier la centralité par une seconde technique (questionnaire de mise en cause) ; juger les représentations (« elles sont fausses ») au lieu de les comprendre.

Question 2 – Indicateurs et diagnostic (1,5 pt)

Calcul posé – Indicateurs du questionnaire (n = 160)

- Ne prend rien avant de partir : 98 / 160 × 100 = **61,3 %**.
- Boisson énergisante chaque jour : 54 / 160 × 100 = **33,8 %**.
- Déjeune au self pendant les semaines au CFA : 46 / 160 × 100 = **28,8 %**.
- Sandwich ou restauration rapide au moins 3 midis sur 5 : 88 / 160 × 100 = **55,0 %**.
- Fruits ou légumes chaque jour : 37 / 160 × 100 = **23,1 %**.
- A entendu une moquerie sur ce qu'il mange : 61 / 160 × 100 = **38,1 %**.
- Taux de participation : 160 / 640 × 100 = **25,0 %**.

Stades de changement (Prochaska et DiClemente, 1983) : précontemplation 72 / 160 = **45,0 %** ; contemplation 40 / 160 = **25,0 %** ; préparation 22 / 160 = **13,8 %** ; action 16 / 160 = **10,0 %** ; maintien 10 / 160 = **6,3 %**. La somme des arrondis fait 100,1 % ; on le signale sans modifier les valeurs.

Diagnostic. Le comportement le plus fréquent est l'absence de prise alimentaire avant le chantier (61,3 %), souvent remplacée par une boisson énergisante (33,8 %), alors que l'ANSES (2013) déconseille ces boissons lors d'un effort physique. Le midi, l'alimentation est surtout faite de sandwichs ou de restauration rapide (55,0 %) et les fruits et légumes sont rares (23,1 %). Le contexte social pèse : plus d'un apprenti sur trois (38,1 %) a déjà été moqué pour ce qu'il mange, ce qui montre une **norme de groupe** défavorable. Enfin, **70,0 %** des apprentis (45,0 + 25,0) ne sont pas encore prêts à agir : une campagne d'information classique toucherait surtout les 30 % déjà prêts.

Type de besoin (Bradshaw, 1972)	Dans la situation
Normatif	Repères PNNS non atteints ; avis de l'ANSES (2013) sur les boissons énergisantes à l'effort ; malaises signalés par l'infirmière
Ressenti	Absence de faim à 5 h 45, fatigue, envie de « prendre du muscle »
Exprimé	Rejet des messages moralisateurs ; intérêt pour l'alimentation du sportif ; demande de l'infirmière
Comparatif	Les apprentis qui vivent seuls sautent plus souvent la prise du matin que ceux qui vivent chez leurs parents (question 7)

Problème central : une majorité d'apprentis du CFA de Vauclair (61,3 % des répondants) commence la journée de chantier sans rien manger, dans un contexte de normes de groupe et de représentations qui dévalorisent les légumes et le petit-déjeuner, ce qui les expose à des malaises et à des accidents. **Causes** : départ très matinal, absence de faim, rien à manger chez soi, modèle des adultes (« mon patron ne mange rien »), moqueries entre pairs, représentation du « vrai repas », budget limité, perte du repas familial pour ceux qui vivent seuls. **Conséquences** : malaises, baisse de vigilance (travail en hauteur, outils), consommation de boissons énergisantes, apports insuffisants en fibres et en vitamines.

Question 3 – Échelle de Likert et théorie du comportement planifié (1,5 pt)

Calcul posé – Scores par dimension (items négatifs inversés : score inversé = 6 – score)

- Attitude : A1 = 3,8 ; A2 inversé = 6 – 3,1 = 2,9 ; score = (3,8 + 2,9) / 2 = **3,35**.
- Norme sociale : N1 = 2,4 ; N2 = 2,1 ; score = (2,4 + 2,1) / 2 = **2,25**.

- Contrôle comportemental perçu : C1 = 2,0 ; C2 inversé = 6 − 3,4 = 2,6 ; score = (2,0 + 2,6) / 2 = **2,30**.
- Intention : I1 = **2,6**.

Le point neutre de l'échelle est 3.

Interprétation. Selon Ajzen (1991), l'intention dépend de l'attitude, de la norme subjective et du contrôle perçu. Ici, l'**attitude** est plutôt favorable (3,35, au-dessus du point neutre) : les apprentis savent que manger le matin aide à tenir. En revanche, la **norme sociale** (2,25) et le **contrôle perçu** (2,30) sont nettement défavorables : leurs modèles (maître d'apprentissage, collègues) ne mangent pas le matin, et ils se sentent incapables de le faire (heure, absence de faim, rien chez soi). L'**intention** reste faible (2,6). Conclusion : un message qui répète « le petit-déjeuner est important » serait inutile, car l'attitude est déjà acquise. Les leviers sont **la norme** (faire évoluer ce que font et pensent les adultes et les pairs de référence) et **le contrôle perçu** (solutions simples, préparées la veille, à manger dans la camionnette ou à la première pause de 9 h).

Limites – Ce que les moyennes ne disent pas

Une moyenne de groupe cache des profils différents (un apprenti de 16 ans qui vit chez ses parents et un apprenti de 22 ans qui vit seul). Deux items par dimension sont peu : on ne peut pas vérifier la cohérence interne de l'échelle. À l'oral, présentez ces scores comme des tendances, pas comme une mesure exacte.

Question 4 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : d'ici juin 2027, améliorer l'alimentation du matin et du midi des apprentis du CFA de Vauclair afin de réduire les malaises sur les chantiers.
- **Objectif spécifique 1** : d'ici juin 2027, réduire de 61,3 % à 45 % au plus la part des apprentis qui ne prennent rien à manger avant de partir sur le chantier.
- **Objectif spécifique 2** : d'ici juin 2027, augmenter de 23,1 % à 35 % au moins la part des apprentis qui mangent des fruits ou des légumes chaque jour.
- **Objectifs opérationnels** : former 12 apprentis relais volontaires avant le 15 décembre 2026 (indicateur : nombre de relais formés, feuille de présence) ; organiser 8 « casse-croûtes du lundi » au CFA entre janvier et mai 2027, avec au moins 60 apprentis présents à chacun (indicateur : comptage) ; animer 6 ateliers « casse-croûte de chantier préparé la veille » de janvier à avril 2027 (indicateur : nombre d'ateliers et de participants) ; présenter le projet aux maîtres d'apprentissage lors de la réunion annuelle de mars 2027 et obtenir l'accord d'au moins 20 entreprises pour une pause collation à 9 h (indicateur : nombre d'engagements signés) ; créer avec la société de restauration une « assiette du bâtisseur » proposée chaque jour au self dès février 2027 (indicateur : nombre d'assiettes servies).

Question 5 – Plan d'action et budget (1,5 pt)

Action	Contenu	Concept de psychologie sociale mobilisé
1. Apprentis relais	12 volontaires de différents métiers, formés en deux demi-journées (repères simples, écoute, animation) ; ils co-construisent les actions et les messages	**Influence des pairs** et pair-éducation : un message porté par un membre du groupe est plus crédible ; respect de l'**identité** du groupe
2. « Le casse-croûte du lundi »	Petit-déjeuner partagé à 7 h 45 les semaines de formation : pain, fromage, œufs durs, fruits, yaourts à boire, préparés par les apprentis relais	**Norme descriptive** rendue visible (« ici, on mange le matin ») ; **expérience vicariante** (Bandura) ; plaisir et convivialité, éléments du noyau
3. Atelier « casse-croûte de chantier »	Préparer la veille, en 10 minutes et pour moins de 2 €, une boîte qui cale (pain, œuf dur, fromage, fruit, restes du dîner) et une gourde ; chaque participant repart avec sa boîte	**Contrôle perçu** et **sentiment d'efficacité personnelle** (expérience de réussite) ; **engagement** (Joule et Beauvois, 1998) : un acte concret, choisi librement, rend le comportement plus probable

Action	Contenu	Concept de psychologie sociale mobilisé
4. Maîtres d'apprentissage	Intervention à la réunion annuelle, avec l'organisme de prévention du BTP : lien entre jeûne matinal, vigilance et accidents ; proposition d'une pause collation à 9 h	**Norme subjective** : le maître d'apprentissage est un modèle et une référence ; action sur l'**environnement** de travail
5. « Assiette du bâtisseur » au self	Assiette copieuse construite avec la restauration et les relais : viande ou œufs, féculents, légumes intégrés au plat (gratin, poêlée), pain ; nom choisi par les apprentis	S'appuyer sur le **noyau central** (calé, force) pour y attacher les légumes ; **nudge** (placement en tête de ligne)
6. Séances CPS « Les moqueries, on en parle »	Deux séances par classe avec la CPE : repérer la pression du groupe, savoir dire non, s'affirmer sans agressivité	**Compétences psychosociales** sociales (communiquer de façon constructive, résoudre des difficultés) ; lutte contre la **stigmatisation**

Calcul posé – Budget prévisionnel (prix construits pour le sujet)

- Casse-croûtes du lundi : 8 matinées × 80 apprentis × 0,90 € = **576,00 €**.
- Gourdes isothermes : 160 × 3,50 € = **560,00 €**.
- Matériel de formation des 12 apprentis relais : **120,00 €**.
- Supports (affiches, autocollants pour casques, montage de la vidéo réalisée par les apprentis) : **180,00 €**.
- Kit de démonstration « casse-croûte de chantier » (boîtes, sacs isothermes, denrées pour les ateliers) : **150,00 €**.
- Sous-total : 576 + 560 + 120 + 180 + 150 = 1 586,00 €.
- Imprévus : 1 700 − 1 586 = **114,00 €**, soit 114 / 1 700 × 100 = 6,7 % du budget.

Total : **1 700,00 €**, soit exactement le budget.

Question 6 – Évaluation et valorisation (1 pt)

Type	Indicateurs	Outils
Processus	Nombre de relais formés, de casse-croûtes et d'ateliers, d'apprentis présents, d'entreprises engagées ; respect du budget	Feuilles de présence, tableau de bord, comptes
Résultats	Part des apprentis qui ne mangent rien le matin ; part qui mange des fruits ou des légumes chaque jour ; scores de norme et de contrôle perçu ; place des « légumes » et du « petit-déjeuner » dans une nouvelle évocation hiérarchisée	Même questionnaire, même échelle et même consigne en mai 2027, sur un échantillon comparable
Impact (à moyen terme)	Nombre de malaises signalés à l'infirmerie et par les entreprises	Registre de l'infirmerie (données agrégées), comparaison avec l'année précédente

Valorisation : bilan au conseil de perfectionnement du CFA ; article dans la lettre aux entreprises ; présentation au réseau régional des CFA et à l'organisme de prévention du BTP ; fiche action déposée dans la base régionale des actions de promotion de la santé ; reconduction par les apprentis relais de l'année suivante.

Partie B – Recherche appliquée

Question 7 – Risque relatif (1,5 pt)

Calcul posé – Risque relatif de ne rien manger avant de partir selon le logement

- Exposés (vivent seuls ou au foyer) : 42 / 56 = 0,750, soit **75,0 %**.
- Non exposés (vivent chez leurs parents) : 56 / 104 = 0,538, soit **53,8 %**.
- Risque relatif RR = 0,750 / 0,538 = **1,39**.

Vérification des effectifs : 56 + 104 = 160 répondants ; 42 + 56 = 98 apprentis qui ne mangent rien, comme dans le tableau.

Interprétation : les apprentis qui vivent seuls ou au foyer ont **1,4 fois plus de risque** de ne rien manger avant de partir que ceux qui vivent chez leurs parents. On ne peut pas conclure à une **causalité** : l'enquête est transversale ; l'association peut s'expliquer par des **facteurs de confusion** (âge : les apprentis qui vivent seuls sont plus âgés ; métier ; distance au chantier ; revenus). Il faudrait aussi tester la significativité (intervalle de confiance du RR). L'hypothèse est cependant cohérente avec la **socialisation** : quitter le domicile familial fait perdre le cadre du repas familial (zone contrastée de la question 1, témoignage de Mathis).

Question 8 – Intervalle de confiance, taille d'échantillon et limites des outils (1,5 pt)

Calcul posé – Intervalle de confiance à 95 % et taille d'échantillon

p = 98 / 160 = 0,6125 ; n = 160.

Erreur type = racine de (0,6125 × 0,3875 / 160) = racine de 0,001483 = 0,0385.

Marge = 1,96 × 0,0385 = 0,075, soit 7,5 points.

IC 95 % = [61,3 – 7,5 ; 61,3 + 7,5] = **[53,7 % ; 68,8 %]**.

Taille pour ± 5 points : n = 1,96 × 1,96 × 0,6125 × 0,3875 / (0,05 × 0,05) = 364,7, soit **365** apprentis.

Correction pour une population finie de N = 640 : n' = n / (1 + (n – 1) / N) = 364,7 / (1 + 363,7 / 640) = 364,7 / 1,568 = **233** apprentis.

L'enquête (160 répondants) n'atteint pas cette taille : la précision est de ± 7,5 points, ce qui reste suffisant pour affirmer qu'une majorité ne mange rien le matin (la borne basse, 53,7 %, dépasse 50 %).

Limites des outils :

- **Évocation hiérarchisée** : le regroupement des mots en catégories dépend du jugement de l'enquêteur (il faut le faire à deux et comparer) ; la zone du noyau ne prouve pas la centralité (il faut une seconde technique, comme un questionnaire de mise en cause) ; les mots écrits devant les camarades peuvent suivre la **désirabilité sociale** du groupe (« viande », « force »).
- **Échelle de Likert** : biais d'**acquiescement** (tendance à répondre « d'accord ») ; **tendance centrale** ; deux items seulement par dimension ; items formulés par des adultes, parfois éloignés du langage des apprentis.
- **Échantillon** : 25,0 % de participation ; questionnaire passé pendant la semaine au CFA, ce qui exclut les absents (souvent les plus en difficulté) ; **biais de sélection** possible selon les classes interrogées.

Partie C – Veille

Question 9 – Organiser une veille (2 pts)

- **Besoins** : interventions efficaces en nutrition auprès des jeunes de 16 à 25 ans ; développement des CPS ; influence des réseaux sociaux sur l'alimentation des jeunes ; santé et sécurité des travailleurs du BTP ; boissons énergisantes.
- **Sources fiables** : Santé publique France (référentiel CPS 2022, répertoire des interventions efficaces ou prometteuses, site Manger Bouger) ; ANSES (avis de 2013 sur les boissons dites énergisantes et avis plus récents) ; Fédération Promotion Santé et structures régionales de promotion de la santé ; base OSCARS des actions régionales de santé ; INRS et organisme professionnel de prévention du BTP (OPPBTP) ; bases bibliographiques (Cairn pour la psychologie sociale francophone, PubMed pour les études internationales).
- **Outils** : alertes par courriel et flux RSS des sites officiels ; lettres d'information des structures de promotion de la santé ; tableau de veille partagé (date, source, résumé, utilité pour le projet, action décidée).

- **Fréquence** : une heure par semaine, et une synthèse mensuelle.
- **Diffusion** : note d'une page à l'infirmière, à la CPE et aux apprentis relais ; affichage en salle des formateurs ; point de veille lors des réunions d'équipe.
- **Évaluation** : nombre d'informations utilisées dans le projet ; retour des destinataires sur l'utilité de la note.

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique

Question 10 – Les trois situations du document 5 (1,5 pt)

- **La pesée publique et le classement** : refus. Le poids associé à une personne identifiée est une **donnée de santé**, donnée sensible au sens du RGPD (article 9) : sa collecte doit avoir une finalité légitime, être limitée au nécessaire et rester confidentielle. Publier un classement sur une messagerie de classe expose les apprentis à la **stigmatisation** et à la moquerie, ce qui va contre l'objectif du projet : la stigmatisation liée au poids nuit à la santé (Puhl et Heuer, 2009). Le projet ne vise d'ailleurs pas la perte de poids mais des comportements (manger le matin, manger des légumes).
- **La vidéo de l'apprenti filmé au self** : il s'agit d'une atteinte au **droit à l'image** et à la vie privée (article 9 du code civil) et d'un fait de **cyberharcèlement** : le harcèlement moral est puni par le code pénal (article 222-33-2-2), plus sévèrement lorsqu'il passe par un service de communication en ligne. Conduite à tenir : protéger et écouter le jeune ; prévenir la CPE et la direction ; signaler le contenu à la plateforme et, si besoin, sur PHAROS ; informer le jeune et sa famille du numéro national 3018 (harcèlement et violences numériques) ; ne pas repartager la vidéo, même pour la dénoncer ; utiliser l'événement, sans nommer la victime, dans les séances CPS.
- **La vidéo publique du projet** : elle est possible avec des précautions. Il faut une **autorisation écrite** de chaque personne filmée, signée aussi par les représentants légaux pour les mineurs ; une finalité précise et une durée de diffusion limitée ; aucune information sur le poids ou la santé ; le droit de retirer son accord. Le plus simple est de filmer les **mains, les gestes et les plats**, et de laisser les apprentis relais raconter le projet en voix off, ce qui protège aussi l'**e-réputation** des jeunes et du CFA.
- **Réponse proposée à la direction (exemple)** : « Nous proposons de renoncer à la pesée et au classement : ce sont des données de santé et ils exposeraient les jeunes à la moquerie, que le projet cherche justement à réduire. La vidéo diffusée au self doit être signalée et retirée, et l'apprenti accompagné. Pour la page du CFA, nous réaliserons avec les apprentis relais une vidéo sans visages, centrée sur les gestes et les plats, avec l'accord écrit de chacun. »

Question 11 – Communication, exposé et questions du jury (1,5 pt)

Supports adaptés : messages **positifs et concrets**, dans le langage des apprentis et validés par les relais (« Le carburant du chantier », « Tenir jusqu'à midi ») ; autocollants pour casques et boîtes ; affiches photo des casse-croûtes réalisés ; courtes vidéos sans visages tournées par les apprentis et diffusées sur les écrans du CFA et sur les réseaux du CFA ; défi en ligne « Montre ta boîte » (photo du casse-croûte, sans visage) ; aucun message culpabilisant ni de chiffres de poids. Pour les maîtres d'apprentissage : une fiche d'une page sur le lien entre repas du matin, vigilance et accidents.

Préparer l'oral – Trame de l'exposé de 10 minutes

0 – 1 min : contexte et demande de l'infirmière. 1 – 3 min : représentations (analyse prototypique) et comportements (enquête). 3 – 4 min : attitudes et leviers (théorie du comportement planifié), problème central. 4 – 5 min : objectifs. 5 – 7 min : plan d'action et concepts mobilisés, partenaires, budget. 7 – 8 min : évaluation et premiers résultats observés pendant le stage. 8 – 9 min : éthique (pesée, cyberharcèlement, droit à l'image). 9 – 10 min : bilan personnel et ce que je referais autrement.

Questions probables du jury – Questions probables et réponses attendues

1. Qu'est-ce qu'une représentation sociale ? Une forme de connaissance partagée par un groupe, qui oriente ses conduites (Moscovici, 1961 ; Jodelet, 1989).
2. Comment avez-vous fixé les seuils de l'analyse prototypique ? Moyenne des fréquences et moyenne des rangs moyens.

3. Le noyau central est-il prouvé ? Non : la zone du noyau donne des candidats ; il faut une seconde technique pour confirmer.

4. Pourquoi ne pas avoir dit aux jeunes de manger cinq fruits et légumes ? Le message est connu, il attaque leur représentation et provoque de la réactance.

5. Qu'est-ce qu'une norme descriptive ? Ce que font la plupart des membres du groupe, à distinguer de la norme injonctive (ce qu'il faudrait faire).

6. Pourquoi inverser certains items ? Pour que tous les scores aillent dans le même sens et pour limiter le biais d'acquiescement.

7. Pourquoi agir sur le contrôle perçu plutôt que sur l'attitude ? L'attitude est déjà favorable (3,35) ; le contrôle (2,30) et la norme (2,25) freinent l'intention.

8. Qu'est-ce que le sentiment d'efficacité personnelle ? La croyance en sa capacité à réussir une action ; il se renforce par les expériences de réussite (Bandura, 1977).

9. Comment avez-vous recruté les apprentis relais ? Volontariat, plusieurs métiers et âges, accord des formateurs.

10. Votre RR montre-t-il que vivre seul fait sauter le petit-déjeuner ? Non : association, enquête transversale, facteurs de confusion comme l'âge.

11. Que faites-vous face à un cas de cyberharcèlement ? Protéger, signaler, ne pas repartager, orienter (3018), en lien avec la CPE.

12. Pourquoi ne pas peser les jeunes ? Ce n'est pas l'objectif ; données de santé ; risque de stigmatisation.

13. Que proposez-vous à un apprenti qui n'a pas faim à 5 h 45 ? Une collation à la pause de 9 h, préparée la veille, et un verre d'eau ou de lait au réveil.

14. Comment avez-vous associé les maîtres d'apprentissage ? Réunion annuelle, organisme de prévention du BTP, lien avec la sécurité.

15. Quelles CPS travaillez-vous et comment ? Communiquer de façon constructive et résoudre des difficultés, par des jeux de rôle sur la pression du groupe.

16. Comment le projet peut-il durer ? Relais renouvelés chaque année, assiette du bâtisseur intégrée au marché du self, inscription au projet d'établissement.

Grille d'évaluation et barème

Partie	Indicateurs du référentiel évalués	Points
A – Projet	Analyse et diagnostic de situation posé (représentations, comportements, attitudes, besoins) ; objectifs formulés et adaptés ; plan d'action justifié par des concepts et moyens réalistes ; évaluation et valorisation (C3.1)	9
B – Recherche	Traitement et analyse des données (RR, IC, taille d'échantillon) ; limites des outils de recueil ; prudence sur la causalité (C3.3)	3
C – Veille	Besoins identifiés ; sources fiables ; outils et diffusion (C3.4)	2
D – Communication et numérique	Supports adaptés au public ; droit à l'image ; cyberharcèlement ; confidentialité des données de santé (C3.5, C3.6)	3
Expression	Expression écrite et orale maîtrisée ; vocabulaire ; sources datées	3
Total		20

Niveaux de maîtrise pour chaque partie : non maîtrisé (moins de 25 % des points), insuffisamment maîtrisé (25 à 49 %), maîtrisé (50 à 79 %), bien maîtrisé (80 % et plus).

Corrigé S2 – « Les hommes aux fourneaux » : un atelier pour des hommes âgés qui vivent seuls

que le jury attend

Le jury attend un atelier pensé pour des hommes âgés qui n'ont jamais cuisiné : des gestes simples, des réussites rapides, une ambiance entre pairs, sans infantiliser. Il évalue la justesse des calculs (quantités brutes, coût, apports Ciqual), l'adaptation aux pathologies et aux difficultés (diabète, mastication, sel, vue, mobilité), la sécurité sanitaire (poisson, cuisson, restes) et la compréhension des freins psychosociaux. Il pénalise les recettes trop techniques, les adaptations qui retirent tout plaisir et le discours « il faut maigrir » chez une personne âgée qui perd du poids.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Besoins et objectifs (2 pts)

Besoins **nutritionnels** : prévenir la dénutrition (deux hommes ont perdu plus de 5 % de leur poids en six mois ; ce n'est pas encore le critère de la HAS, qui est d'au moins 10 % en six mois, mais c'est un signal d'alerte qui justifie un dépistage par le médecin traitant) ; apporter assez de protéines (environ 1,0 g par kg et par jour, AFSSA 2007), de la vitamine D et des fibres ; repas du soir régulier. Besoins **psychologiques** : sentiment d'efficacité personnelle très faible (« je ne sais même pas faire cuire un œuf ») ; perte de repères après le deuil, le repas étant lié à l'épouse disparue. Besoins **sociaux** : isolement, perte des repas partagés, gêne à rejoindre un groupe majoritairement féminin.

- **Objectif général** : permettre à des hommes âgés vivant seuls de préparer eux-mêmes des repas simples, équilibrés et adaptés à leur santé, et de retrouver le plaisir de manger, si possible en compagnie.
- **Objectifs opérationnels** : à la fin de l'atelier, chaque participant aura réalisé lui-même au moins trois gestes (éplucher, émincer, fermer une papillote, mélanger un crumble) (observation) ; aura goûté le repas complet et donné son avis sur la grille (grilles remplies) ; repartira avec la fiche « pour un » en gros caractères et saura citer le temps de cuisson de la papillote et une règle de conservation des restes (question orale en fin de séance) ; aura choisi la recette de la séance suivante avec le groupe (décision notée).

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 10 portions

Quantité nette totale = grammage net × 10 ; quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte) ; coût = quantité brute en kg × prix au kg.

Denrée	Quantité nette	Quantité brute	Unité de commande	Prix unitaire	Coût
Filets de lieu noir	1 200 g	1 200 g	1,200 kg	12,90 € le kg	15,48 €
Poireaux	1 000 g	1 000 / 0,70 = 1 428,6 g	1,429 kg	2,20 € le kg	3,14 €
Pommes de terre	2 000 g	2 000 / 0,80 = 2 500 g	2,500 kg	1,20 € le kg	3,00 €
Crème légère 15 % MG	150 g	150 g	0,150 kg	3,40 € le kg	0,51 €
Citrons	100 g	100 / 0,60 = 166,7 g	0,167 kg	3,00 € le kg	0,50 €
Pommes	600 g	600 / 0,80 = 750 g	0,750 kg	2,40 € le kg	1,80 €
Poires	600 g	600 / 0,80 = 750 g	0,750 kg	2,80 € le kg	2,10 €
Flocons d'avoine	150 g	150 g	0,150 kg	2,00 € le kg	0,30 €
Farine T55	100 g	100 g	0,100 kg	1,10 € le kg	0,11 €
Beurre doux	80 g	80 g	0,080 kg	9,50 € le kg	0,76 €
Sucre blanc	60 g	60 g	0,060 kg	1,30 € le kg	0,08 €

Denrée	Quantité nette	Quantité brute	Unité de commande	Prix unitaire	Coût
Papier sulfurisé, aneth, poivre, cannelle	–	–	forfait	–	0,80 €
Total					28,58 €

Coût par portion = 28,58 / 10 = **2,86 €**, inférieur au plafond de 3,00 € : le budget est respecté, avec une marge de 0,14 € par portion. Le poisson représente 15,48 / 28,58 × 100 = 54,2 % du coût : pour les séances suivantes, on peut proposer du lieu noir surgelé, souvent moins cher, ou des œufs.

Question 3 – Fiche technique, fiche « pour un » et adaptations (3 pts)

Modèle – Fiche technique de la papillote de lieu noir (10 portions)

Ingrédients : filets de lieu noir 1,200 kg ; poireaux 1,000 kg nets ; crème légère 150 g ; 2 citrons ; aneth ; poivre ; pommes de terre 2,000 kg nettes.

Matériel : four à 200 °C, plaques, papier sulfurisé (10 feuilles de 35 cm), cuit-vapeur ou faitout avec panier, planches et couteaux (code couleur poisson et légumes), économes, thermomètre-sonde, balance, saladiers.

1. Se laver les mains ; sortir le poisson du réfrigérateur au dernier moment.
2. Laver soigneusement les poireaux (terre entre les feuilles), les émincer finement ; les faire fondre 10 minutes à couvert dans une sauteuse avec un peu d'eau.
3. Éplucher, laver, tailler les pommes de terre en morceaux réguliers ; les cuire à la vapeur 20 à 25 minutes.
4. Sur chaque feuille, déposer un lit de poireaux, un filet de poisson, 15 g de crème, une rondelle de citron, de l'aneth, du poivre (pas de sel ajouté).
5. Fermer la papillote en roulant les bords ; cuire 15 minutes au four à 200 °C.
6. Contrôler la cuisson : la chair se détache en lamelles nacrées ; température à cœur d'au moins 63 °C.
7. Servir dans la papillote ouverte, avec les pommes de terre.

Points critiques : chaîne du froid du poisson (0 à 2 °C), arêtes à vérifier du bout des doigts, cuisson à cœur, séparation des planches cru et cuit, vapeur brûlante à l'ouverture de la papillote.

Fiche « pour un » (gros caractères, une étape par photo) : un filet de poisson frais ou surgelé (sans décongeler, ajouter 5 minutes de cuisson), un demi-poireau émincé ou une poignée de poireaux surgelés, une cuillère à soupe de crème, une rondelle de citron ; papillote fermée ; 15 à 20 minutes à 200 °C au four, ou 4 à 5 minutes au four à micro-ondes dans un plat couvert (sans papier aluminium). Pommes de terre : 2 ou 3 pommes de terre coupées en morceaux, 8 à 10 minutes au micro-ondes dans un bol couvert avec 2 cuillères à soupe d'eau. Crumble « pour un » : un fruit coupé dans un ramequin, deux cuillères à soupe du mélange flocons-farine-beurre préparé à l'avance et gardé au réfrigérateur, 20 minutes au four ou 3 minutes au micro-ondes (moins croustillant).

Adaptations :

- **Monsieur R. (diabète de type 2)** : le repas est déjà adapté (féculents en quantité habituelle, fibres, dessert pris en fin de repas). On supprime le sucre du crumble et on parfume à la cannelle : les glucides du dessert passent de 36,0 g à 30,1 g, et les sucres de 18,8 g à 12,8 g. On ne supprime pas le dessert, qui fait partie du plaisir du repas.
- **Monsieur P. (mastication)** : le poisson et les poireaux fondus sont déjà tendres ; on écrase les pommes de terre à la fourchette avec un peu de jus de cuisson et de crème ; on remplace le crumble croustillant par une compote pommes-poires avec les flocons d'avoine trempés dans un peu de lait. On garde une présentation soignée (assiette séparée, pas de mixé), car il s'agit d'une texture tendre, pas d'un régime mixé.

- **Monsieur L. (sel)** : aucun sel ajouté dans la recette (0,31 g de sel naturellement présent dans le plat) ; on donne du goût par le citron, l'aneth, le poivre, l'ail ; on lui apprend à repérer le sel sur les étiquettes des plats tout prêts qu'il achète.

Question 4 – Apports nutritionnels (2 pts)

Calcul posé – Apport d'une portion (table Ciqual 2025, document 4)

Apport = grammage net × teneur pour 100 g / 100. Les teneurs « < » ou « – » sont comptées 0.

Ingrédient (plat)	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Vitamine D (µg)
Lieu noir	120 g	99,0	22,56	0	0,96	0	0,24	2,12
Poireau	100 g	30,4	1,50	4,55	0,30	1,80	0,05	0
Pomme de terre	200 g	160,0	4,04	32,40	0,18	4,40	0	0
Crème légère	15 g	26,0	0,44	0,65	2,40	0	0,02	0
Citron	10 g	2,4	0,03	0,16	0	0	0	0
Total plat		317,8	28,6	37,8	3,8	6,2	0,31	2,12
Crumble (pomme 60 g, poire 60 g, flocons 15 g, farine 10 g, beurre 8 g, sucre 6 g)		235,1	2,9	36,0	8,1	5,3	0,01	0
Repas complet		552,9	31,4	73,8	11,9	11,5	0,32	2,12

Répartition de l'énergie du repas : protéines 31,42 × 4 / 552,9 = **22,7 %** ; lipides 11,90 × 9 / 552,9 = **19,4 %** ; glucides 73,79 × 4 / 552,9 = **53,4 %** ; le reste (4,2 %) vient surtout des fibres, comptées 2 kcal par gramme dans le calcul réglementaire de l'énergie (11,49 × 2 / 552,9).

Part du besoin en protéines d'un homme de 75 kg (1,0 g par kg et par jour, soit 75 g) : 31,4 / 75 × 100 = **41,9 %**.

Fibres : 11,5 / 30 × 100 = **38,3 %** du repère journalier. Sel : 0,32 g, soit 6,4 % de la limite de 5 g. Vitamine D : 2,12 / 15 × 100 = **14,1 %** de l'apport satisfaisant.

Commentaire : le repas est **riche en protéines** (41,9 % du besoin journalier en un repas), **pauvre en sel** (adapté à Monsieur L.) et apporte plus du tiers des fibres de la journée. Sa part de lipides est faible (19,4 %) : pour des hommes qui perdent du poids, il ne faut pas chercher à « alléger ». On peut enrichir sans augmenter le volume (un peu plus de crème, un filet d'huile de colza sur les pommes de terre, un fromage ou un laitage en plus), comme le recommande la prévention de la dénutrition. La vitamine D reste faible : le poisson en apporte, mais l'exposition au soleil et l'avis du médecin (supplémentation) comptent davantage chez la personne âgée.

Question 5 – Pourquoi ces hommes ne cuisinent pas, et ce que l'atelier peut changer (2 pts)

- **Identité et rôles de genre** : dans la **socialisation** de ces générations, la cuisine quotidienne était un rôle féminin ; cuisiner peut être vécu comme une perte de statut, et l'atelier « plein de dames » renforce la gêne. Un atelier **entre hommes**, au nom valorisant, avec des gestes techniques (papillote, cuisson au four), réduit cette menace identitaire.
- **Sentiment d'efficacité personnelle** (Bandura, 1977) : il est très faible ; il se renforce par des **expériences de réussite** (chacun réalise une étape et mange le résultat), par l'**exemple de pairs** qui réussissent (expérience vicariante : un participant un peu plus expérimenté montre un geste), par les **encouragements** et par un climat détendu qui réduit l'anxiété.
- **Deuil et motivation** : le repas rappelle l'épouse disparue ; manger seul diminue l'envie de cuisiner. La motivation durable repose sur l'autonomie (choisir les recettes), la compétence (réussir) et l'appartenance (le groupe), selon la théorie de l'autodétermination.

- **Isolement** : le repas partagé à la fin de l'atelier recrée du lien ; l'atelier peut déboucher sur un repas mensuel entre participants ou au foyer-restaurant.

Limites d'un atelier isolé : une seule séance ne change pas des habitudes ; il faut le **cycle de six séances**, un lien avec le médecin traitant (dépistage de la dénutrition, pesée régulière), le portage de repas si besoin, l'accès aux courses (mobilité, canne) et un suivi après le cycle. L'atelier n'agit pas sur les revenus ni sur la solitude au quotidien.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté des 3 heures (2 pts)

Horaire	Candidat	Participants
8 h 30 – 9 h 30	Mise en place : contrôle des denrées et des températures, postes de travail à hauteur réglable, chaises disponibles, fiches en gros caractères, couteaux et économes ergonomiques ; préchauffage du four	–
9 h 30 – 9 h 45	Accueil autour d'un café ; présentation de chacun ; règles de sécurité ; lavage des mains montré puis réalisé	Se présentent, se lavent les mains
9 h 45 – 10 h 15	Démonstration courte puis travail en binômes : épluchage des pommes de terre, lavage et émincé des poireaux ; parler fort, face au groupe, montrer de près	Épluchent, émincent ; s'assoient s'ils le souhaitent
10 h 15 – 10 h 40	Crumble : couper les fruits, sabler le mélange avec les doigts ; enfournement	Préparent le crumble, version sans sucre pour M. R.
10 h 40 – 11 h 10	Papillotes : chaque participant monte et ferme la sienne ; cuisson des pommes de terre à la vapeur	Montent leur papillote
11 h 10 – 11 h 30	Cuisson des papillotes ; pendant ce temps, échange sur les courses « pour un », lecture d'étiquette (sel)	Échangent, posent des questions
11 h 30 – 12 h 00	Dressage, repas partagé, grille de dégustation, choix de la recette suivante, remise des fiches	Mangent ensemble, évaluent, décident
12 h 00 – 12 h 30	Remise en état, plonge, nettoyage et désinfection, gestion des déchets, bilan écrit	Ceux qui le souhaitent aident à ranger

Question 7 – Animation, outils et grille de dégustation (1,5 pt)

Méthodes qui renforcent l'efficacité personnelle : **démonstration courte puis pratique immédiate** ; difficulté progressive (on commence par un geste facile et réussi) ; **valorisation concrète** (« votre papillote est parfaitement fermée ») ; entraide entre pairs ; droit à l'erreur et humour ; jamais faire à la place. Outils : fiche recette en police de 16 points au moins, très contrastée, une étape par photo ; quantités en repères visuels (une cuillère à soupe, une poignée) ; minuteur à gros chiffres ; plan de travail bien éclairé. Grille de dégustation : trois questions simples (aspect, goût, envie de refaire), réponse par une note de 1 à 4 ou par des visages, remplie oralement si la vue est gênée ; une question ouverte : « Que changeriez-vous ? ».

Question 8 – Hygiène, conservation des restes, allergènes, éco-gestes (1,5 pt)

Hygiène (5 M) : **main-d'œuvre** (lavage des mains, tablier, cheveux attachés, plaies protégées) ; **milieu** (plans de travail nettoyés et désinfectés, marche en avant) ; **matériel** (planches distinctes pour le poisson cru et les légumes) ; **matière** (poisson conservé entre 0 et 2 °C jusqu'au dernier moment, poireaux bien lavés) ; **méthode** (cuisson à cœur d'au moins 63 °C, service rapide). À domicile : mettre les restes au réfrigérateur dans une boîte fermée dans les deux heures, les consommer dans les 24 heures pour le poisson cuit, réchauffer une seule fois jusqu'à ce que ce soit très chaud ; vérifier la température du réfrigérateur (4 °C au plus) ; dates limites lisibles avec une loupe ou en gros caractères. Allergènes à déclarer : **poisson**, **lait** (crème, beurre), **gluten** (farine, flocons d'avoine). Éco-gestes : légumes de saison (poireaux, pommes, poires en hiver), épluchures au compost, cuisson

simultanée des papillotes et du crumble dans le four, eau de cuisson vapeur limitée, restes emportés dans des boîtes réutilisables, poisson issu d'une pêche durable (label).

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (3 pts)

Critères : poisson nacré, qui se détache en lamelles, cuit à cœur ; poireaux fondants ; papillote bien fermée puis ouverte au service ; pommes de terre cuites et entières (version écrasée pour M. P.) ; crumble doré et croustillant, fruits tendres ; assiette de M. P. aussi soignée que les autres ; respect des températures, du temps et de l'hygiène ; poste propre en fin de séance.

Question 10 – Évaluation (1 pt)

Satisfaction : grille de dégustation et tour de table. Acquis : chaque participant cite le temps de cuisson de la papillote et une règle de conservation. **Sentiment de compétence** : question « De 1 à 10, vous sentez-vous capable de refaire ce plat seul chez vous ? », posée au début et à la fin de l'atelier, puis à la dernière séance du cycle. Intention et comportement : « Allez-vous refaire ce plat cette semaine ? », puis à la séance suivante « L'avez-vous refait ? ». Suivi : nombre de participants présents aux six séances, évolution du poids suivie par le médecin traitant (donnée de santé, non recueillie par l'atelier).

Barème – Barème du sujet

Besoins et objectifs 2 ; bon de commande 2 ; fiche technique, fiche « pour un » et adaptations 3 ; apports nutritionnels 2 ; analyse psychosociale et limites 2 ; déroulé 2 ; animation et outils 1,5 ; hygiène, allergènes, éco-gestes 1,5 ; réalisation 3 ; évaluation 1 ; total 20.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Oublier les pertes au parage des poireaux (30 %) ; proposer un menu « allégé » à des hommes qui perdent du poids ; supprimer le dessert du diabétique ; mixer le repas de M. P. alors qu'une texture tendre suffit ; ajouter du sel ; faire les gestes à la place des participants ; oublier les allergènes poisson, lait et gluten ; ignorer la vue et la mobilité dans l'organisation.

Corrigé S3 – Vers l'autonomie : des jeunes de la protection de l'enfance

que le jury attend

Le jury attend un projet construit **avec** les jeunes et non pour eux : des jeunes qui se méfient des adultes qui décident à leur place, qui ont souvent vécu des ruptures, et pour qui l'autonomie alimentaire fait partie de l'accès à une vie d'adulte. Il évalue la rigueur des indicateurs, la mobilisation juste de la socialisation, des CPS et de l'autodétermination, la faisabilité dans des studios peu équipés, et les précautions éthiques propres à la protection de l'enfance. Il pénalise les ateliers « scolaires », les jugements sur les familles et les photos de jeunes publiées sans précaution.

Temps 1

Question 1 – Indicateurs, efficacité personnelle et limites (4 pts)

Calcul posé – Indicateurs de l'enquête (n = 22)

- Saute au moins un repas par jour, 4 jours sur 7 : 13 / 22 × 100 = **59,1 %**.
- Plat préparé, livraison ou restauration rapide au moins 4 fois par semaine : 15 / 22 × 100 = **68,2 %**.
- Sait cuisiner au moins 3 plats sans aide : 6 / 22 × 100 = **27,3 %**.
- Fait ses courses avec une liste : 4 / 22 × 100 = **18,2 %**.
- Plus d'argent pour manger avant la fin du mois : 12 / 22 × 100 = **54,5 %**.
- Souhaite apprendre à cuisiner : 17 / 22 × 100 = **77,3 %**.
- Taux de réponse : 22 / 24 × 100 = **91,7 %**.

Score moyen d'efficacité personnelle = (2,1 + 2,4 + 1,9 + 3,0 + 2,2 + 2,6) / 6 = 14,2 / 6 = **2,37** sur 5 (point neutre : 3).

Les deux capacités les plus faibles sont **cuisiner pour des amis** (1,9) et **préparer un repas complet** (2,1) ; la plus forte est **lire une étiquette et comparer deux produits** (3,0), qui est la seule à atteindre le point neutre. Lecture : les jeunes savent plutôt « lire » l'alimentation, mais ne se sentent pas capables de la « faire ». Le levier n'est donc pas l'information mais la **pratique** : des expériences de réussite répétées. La forte demande (77,3 %) est un atout : la motivation existe.

Limites : petit effectif (22 jeunes : un jeune représente 4,5 points de pourcentage) ; questionnaire rempli en temps collectif, avec un risque de **désirabilité sociale** et d'influence du groupe ; aide d'une éducatrice pour la lecture, qui peut orienter les réponses ; échelle d'efficacité personnelle construite pour le service, non validée ; données déclaratives ; pas de comparaison possible avec une population générale du même âge.

Question 2 – Analyse psychosociale et inégalité sociale de santé (3 pts)

- **Socialisation primaire** : elle se fait surtout dans la famille ; pour ces jeunes, elle a été marquée par des ruptures (placement), et l'apprentissage ordinaire de la cuisine, des courses et du repas familial a souvent manqué.
- **Socialisation secondaire** : en foyer, « tout était fait » ; l'institution a nourri les jeunes sans toujours leur apprendre à se nourrir. Le passage en studio les place brutalement devant des tâches jamais apprises.
- **Identité** : à 16-20 ans, l'identité se construit en partie contre les adultes et avec les pairs ; la nourriture rapide et la livraison peuvent être des marqueurs d'appartenance et de liberté. Le repas peut aussi réveiller des souvenirs familiaux douloureux.
- **Compétences psychosociales** (Santé publique France, 2022) : l'autonomie alimentaire mobilise des CPS cognitives (prendre des décisions constructives : choisir, planifier, gérer un budget), émotionnelles (gérer son stress et sa fatigue, ne pas « compenser » par la livraison) et sociales (cuisiner et manger avec d'autres, demander de l'aide).
- **Théorie de l'autodétermination** (Deci et Ryan) : la motivation durable suppose de satisfaire les besoins d'**autonomie** (choisir, ne pas subir « des adultes qui décident pour nous »), de **compétence** (réussir, ce que

montre le faible score d'efficacité personnelle) et d'**appartenance** (le groupe des pairs, un adulte de confiance).

C'est une **inégalité sociale de santé** : ces jeunes cumulent des ressources économiques faibles (54,5 % manquent d'argent pour manger en fin de mois), un soutien familial absent ou fragile et une entrée dans l'autonomie plus précoce que les jeunes du même âge, qui restent en moyenne plus longtemps chez leurs parents. Le document 1 montre que le passage par la protection de l'enfance est surreprésenté parmi les personnes sans domicile (23 % des personnes sans domicile nées en France). Ces écarts sont **évitables** et **injustes** : ils ne viennent pas de choix individuels mais d'un parcours de vie.

Question 3 – Objectifs et plan d'action sur 12 mois (5 pts)

- **Objectif général** : d'ici décembre 2027, permettre aux jeunes du service « Les Passerelles » de se nourrir seuls de façon suffisante, variée et économique, en préparant leur sortie du dispositif.
- **Objectif spécifique 1** : d'ici décembre 2027, porter de 27,3 % à 60 % au moins la part des jeunes qui savent cuisiner au moins 3 plats sans aide.
- **Objectif spécifique 2** : d'ici décembre 2027, réduire de 54,5 % à 35 % au plus la part des jeunes qui n'ont plus d'argent pour manger avant la fin du mois.
- **Objectif spécifique 3** : d'ici décembre 2027, faire passer le score moyen d'efficacité personnelle de 2,37 à 3,2 au moins.
- **Objectifs opérationnels** : constituer avant février 2027 un **comité de jeunes** (4 volontaires) qui choisit les recettes, les horaires et le nom des ateliers (compte rendu de réunion) ; organiser 6 ateliers culinaires de février à novembre 2027, à des horaires compatibles avec les emplois du temps (17 h 30 ou samedi midi), avec au moins 6 jeunes à chacun (feuilles de présence) ; réaliser 4 sorties « courses accompagnées » avec un budget de 30 € pour la semaine (fiches de courses) ; co-écrire avec les jeunes un livret de 20 recettes « studio » réalisables avec deux plaques et un four à micro-ondes, remis à chaque jeune avant juin 2027 (livrets distribués) ; remettre un kit d'ustensiles aux 12 jeunes qui quittent le service dans l'année (kits remis).

Période	Action	Respect de l'autodétermination
Janvier – février	Réunion des jeunes, création du comité, choix des thèmes (« manger pour 30 € par semaine », « cuisiner une fois, manger quatre fois », « recevoir des amis »)	Les jeunes décident ; participation libre
Février – novembre	6 ateliers culinaires de 2 h, repas pris ensemble	Recettes choisies par le comité ; chacun choisit son poste
Mars – octobre	4 sorties courses accompagnées (marché, supermarché discount, épicerie solidaire), comparaison des prix au kilo	Le jeune tient le budget et choisit les produits
Avril – juin	Écriture et illustration du livret « recettes studio » (photos de plats, sans visages)	Les jeunes sont auteurs du livret
Toute l'année	Accompagnement individuel par l'éducateur référent : liste de courses, budget, essais à domicile	Objectifs fixés par le jeune lui-même
Novembre – décembre	Repas de fin d'année préparé par les jeunes pour les éducateurs ; bilan collectif	Valorisation des compétences ; appartenance

Question 4 – Évaluation et budget (3 pts)

Type	Indicateurs	Outils
Processus	Nombre d'ateliers et de sorties réalisés, nombre de jeunes présents, nombre de réunions du comité, livrets et kits remis, respect du budget	Feuilles de présence, comptes rendus, tableau de bord

Type	Indicateurs	Outils
Résultats	Part des jeunes qui savent cuisiner 3 plats sans aide ; part qui manque d'argent en fin de mois ; score d'efficacité personnelle ; satisfaction	Même questionnaire et même échelle en décembre 2027 ; entretien de groupe
Effets à plus long terme	Situation alimentaire des jeunes 6 mois après leur sortie du service	Questionnaire court envoyé avec leur accord, par le canal qu'ils choisissent

Calcul posé – Budget prévisionnel (prix construits pour le sujet)

- Denrées des 6 ateliers : 6 × 10 portions × 2,00 € = **120,00 €**.
- Boîtes de conservation et de congélation : 24 lots × 9,00 € = **216,00 €**.
- Impression du livret de recettes : 24 × 4,50 € = **108,00 €**.
- Sorties courses accompagnées (transport, achats tests) : 4 × 40,00 € = **160,00 €**.
- Kits d'ustensiles pour les jeunes qui quittent le service : 12 × 18,00 € = **216,00 €**.
- Sous-total : 120 + 216 + 108 + 160 + 216 = 820,00 €.
- Imprévus : 900 – 820 = **80,00 €**, soit 80 / 900 × 100 = 8,9 %.

Total : **900,00 €**, soit exactement le budget.

Question 5 – Précautions éthiques et juridiques (3 pts)

- **Données personnelles** : questionnaire anonyme, sans nom ni date de naissance ; données conservées sur un support sécurisé du service, détruites à la fin du projet ; information des jeunes sur la finalité (RGPD : minimisation, information, sécurité). Les difficultés financières et les habitudes alimentaires d'un jeune identifié sont des informations personnelles sensibles.
- **Secret professionnel** : les personnes qui participent aux missions de l'aide sociale à l'enfance sont tenues au secret professionnel (code de l'action sociale et des familles, article L221-6). La stagiaire ne transmet aucune information individuelle hors de l'équipe ; le partage d'informations se limite à ce qui est nécessaire à l'accompagnement du jeune, avec l'éducateur référent.
- **Photos et réseaux sociaux** : pas de visages ni de lieux reconnaissables ; pour certains jeunes placés, le lieu de vie doit rester confidentiel (protection vis-à-vis de la famille). Toute photo d'un mineur demande l'autorisation des titulaires de l'autorité parentale, après avis du service de l'ASE, et l'accord du jeune ; pour un majeur, son autorisation écrite. On privilégie les photos de plats et de mains.
- **Sujets sensibles** : ne pas demander aux jeunes de raconter les repas de leur enfance ; laisser chacun libre de ne pas participer à une activité ; prévoir avec l'éducateur une conduite à tenir si une émotion forte apparaît ; ne jamais juger les familles.
- **Respect des convictions** : viande halal, végétarisme, sans commentaire ni pression.

Question 6 – Expression et sources (2 pts)

Sources citées et datées : loi du 7 février 2022 ; enquête Sans-domicile 2012 (Insee-Ined, publication 2016) ; référentiel CPS de Santé publique France (2022) ; théorie de l'autodétermination (Deci et Ryan, 1985 et 2000) ; Bandura (1977) pour l'efficacité personnelle ; table Ciqual 2025 ; références nutritionnelles de l'ANSES (2021). Vocabulaire attendu : socialisation primaire et secondaire, identité, CPS, autodétermination, efficacité personnelle, inégalité sociale de santé, secret professionnel.

Temps 2

Question 7 – Besoins, objectifs et choix du menu (3 pts)

Besoins : apprendre une recette complète, économique, réalisable dans un studio avec deux plaques et un four à micro-ondes ; savoir cuisiner en grande quantité et conserver des portions pour les soirs de fatigue (alternative à la livraison) ; gagner en confiance (score d'efficacité personnelle de 2,1 pour « préparer un repas complet »).

Objectif de l'atelier : à la fin de la séance, chaque jeune aura réalisé au moins une étape du chili, aura conditionné et étiqueté une portion à congeler, et saura dire comment la décongeler et la réchauffer.

Choix du menu : le chili est un **plat complet** (légumineuses, viande, légumes, féculent) ; il se prépare dans une seule casserole, se congèle bien et coûte peu ; il est apprécié des jeunes (plat épicé, convivial) et peut se décliner (wraps, gratin, version végétarienne). La viande achetée halal permet à tous de manger le même plat. La salade d'oranges est rapide, de saison en hiver, sans cuisson. Les horaires (17 h 30) tiennent compte du lycée, de l'apprentissage et des emplois.

Question 8 – Bon de commande, fiche technique, apports et version végétarienne (5 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 10 portions

Denrée	Quantité nette	Quantité brute	Unité de commande	Prix unitaire	Coût
Bœuf haché 5 % MG (halal)	600 g	600 g	0,600 kg	11,50 € le kg	6,90 €
Haricots rouges égouttés	800 g	800 g	0,800 kg	2,40 € le kg	1,92 €
Oignons	200 g	200 / 0,90 = 222,2 g	0,222 kg	1,80 € le kg	0,40 €
Poivrons	400 g	400 / 0,80 = 500 g	0,500 kg	3,50 € le kg	1,75 €
Tomates pelées au jus	800 g	800 g	0,800 kg	2,20 € le kg	1,76 €
Huile de colza	50 g	50 / 920 = 0,054 L	0,054 L	3,20 € le litre	0,17 €
Riz blanc	600 g	600 g	0,600 kg	1,80 € le kg	1,08 €
Oranges	1 500 g	1 500 / 0,70 = 2 142,9 g	2,143 kg	2,20 € le kg	4,71 €
Ail, cumin, paprika doux, cannelle	–	–	forfait	–	0,80 €
Total					19,49 €

Coût par portion = 19,49 / 10 = **1,95 €**, inférieur au plafond de 2,00 €. Version « studio » de 4 portions du chili et du riz (sans le dessert) : 2,76 + 0,77 + 0,16 + 0,70 + 0,70 + 0,07 + 0,43 = 5,59 €, soit **1,40 €** la portion, contre 8 à 15 € pour un plat livré.

Modèle – Fiche technique du chili doux (10 portions)

Ingrédients : bœuf haché 600 g ; haricots rouges égouttés 800 g ; oignons 200 g nets ; poivrons 400 g nets ; tomates pelées 800 g ; huile de colza 50 g ; 2 gousses d'ail ; cumin et paprika doux ; riz 600 g.

Matériel : grande sauteuse ou faitout, planches et couteaux (code couleur viande et légumes), passoire, casserole pour le riz, cuillère en bois, thermomètre-sonde, 10 boîtes de congélation et étiquettes.

1. Se laver les mains ; laver les poivrons ; éplucher et ciseler les oignons et l'ail ; tailler les poivrons en dés.
2. Faire revenir oignons et poivrons 5 minutes dans l'huile.
3. Ajouter le bœuf haché, l'émietter et le cuire jusqu'à ce qu'il ne reste plus de partie rose.
4. Ajouter les épices, les tomates et leur jus, puis les haricots rincés et égouttés ; laisser mijoter 20 minutes à feu doux.
5. Cuire le riz dans un grand volume d'eau (environ 12 minutes), l'égoutter.
6. Vérifier la cuisson à cœur (au moins 70 °C pour un plat à base de viande hachée), goûter, rectifier les épices.
7. Servir ; conditionner aussitôt les portions à emporter en boîtes peu profondes, étiqueter (nom du plat, date), refroidir rapidement.

Points critiques : cuisson à cœur de la viande hachée ; planches séparées cru et cuit ; refroidissement rapide des portions ; riz cuit refroidi vite et gardé au froid (Bacillus cereus).

Calcul posé – Apport d'une portion (table Ciqual 2025, document 4)

Ingrédient	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)
Bœuf haché 5 % MG	60 g	78,0	13,14	0,18	2,75	0	0,06	1,59
Haricots rouges	80 g	86,4	6,65	10,40	0,78	5,60	0,54	1,20
Oignon	20 g	7,8	0,22	1,25	0,12	0,34	0,02	0
Poivron	40 g	9,0	0,32	1,40	0,11	0,60	0,01	0,16
Tomates pelées	80 g	17,4	0,63	2,52	0,20	1,52	0,02	0,46
Huile de colza	5 g	45,0	0	0	5,00	0	0	0
Riz blanc	60 g	210,0	4,21	46,50	0,47	0,92	0	1,16
Total chili et riz		453,7	25,17	62,25	9,44	8,98	0,65	4,57
Orange	150 g	63,0	1,12	12,04	0	4,05	0	0,85
Repas complet		516,7	26,30	74,29	9,44	13,03	0,65	5,43

Répartition de l'énergie : protéines 26,30 × 4 / 516,7 = **20,4 %** ; lipides 9,44 × 9 / 516,7 = **16,4 %** ; glucides 74,29 × 4 / 516,7 = **57,5 %** ; fibres 13,03 × 2 / 516,7 = 5,0 % ; la somme (99,3 %) diffère de 100 % à cause des arrondis de la table.

Fer : 5,43 / 11 × 100 = **49,3 %** du repère d'une jeune femme adulte. Fibres : 13,03 / 30 × 100 = **43,4 %** du repère journalier.

Commentaire : repas rassasiant, riche en fibres et en fer (près de la moitié du repère en un repas), peu salé (0,65 g, dont l'essentiel vient des haricots en conserve, qu'on rince) et peu gras. La part des lipides est basse : un jeune très actif peut ajouter du pain ou une portion de fromage.

Version végétarienne : remplacer les 60 g de bœuf par 60 g de haricots rouges en plus (140 g au total). Protéines du chili et du riz : 25,17 − 13,14 + 60 × 8,31 / 100 = 25,17 − 13,14 + 4,99 = **17,02 g** (au lieu de 25,17 g). Pour compenser, on ajoute un œuf dur (50 g, 12,8 g de protéines pour 100 g dans la table Ciqual : 6,4 g) ou un laitage au dessert : on revient à environ 23,4 g. L'association de céréales (riz) et de légumineuses (haricots) améliore la qualité des protéines.

Question 9 – Déroulé, animation et grille de dégustation (4 pts)

Horaire	Candidat	Jeunes
16 h 30 – 17 h 30	Mise en place, contrôle des températures, postes, étiquettes, boîtes ; affiche des étapes en photos	–
17 h 30 – 17 h 45	Accueil, boisson ; présentation du plat choisi par le comité ; règles d'hygiène ; répartition des postes au choix	Choisissent leur poste
17 h 45 – 18 h 30	Préparation en binômes : légumes, cuisson de la viande, mijotage ; riz ; pendant la cuisson, jeu « combien ça coûte ? » (chili maison contre plat livré)	Cuisinent, comparent les prix
18 h 30 – 18 h 45	Salade d'oranges ; conditionnement et étiquetage des portions à emporter	Préparent, étiquettent
18 h 45 – 19 h 30	Repas ensemble, grille de dégustation, idées de variantes, choix de la prochaine recette	Mangent, évaluent, décident
19 h 30 – 20 h 00	Remise en état, refroidissement contrôlé, bilan écrit	Volontaires pour ranger

Animation qui respecte l'autonomie : le jeune choisit son poste et sa variante (plus ou moins épicé) ; l'animatrice explique pourquoi (« on refroidit vite parce que… ») plutôt que d'ordonner ; elle valorise les réussites ; elle ne

fait pas à la place ; elle accepte qu'un jeune observe avant de participer. Grille de dégustation : note de 1 à 5 (aspect, goût, envie de refaire), une question ouverte « Ma variante » ; réponse possible sur tablette ou sur papier.

Question 10 – Hygiène, refroidissement, congélation, allergènes, éco-gestes (4 pts)

Viande hachée : conservée au froid jusqu'au dernier moment, cuite à cœur sans partie rose. Refroidissement : en collectivité, passer de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 heures (arrêté du 21 décembre 2009) ; à la maison, répartir en boîtes peu profondes, ne pas laisser plus de 2 heures à température ambiante, puis réfrigérer ou congeler. Congélation : à – 18 °C, avec une étiquette (plat, date), à consommer dans les 3 mois. Décongélation : au réfrigérateur la veille ou directement au four à micro-ondes, puis réchauffer jusqu'à ce que le plat soit très chaud, une seule fois ; ne jamais recongeler un plat décongelé. Riz cuit : refroidi rapidement et consommé dans les 24 heures au réfrigérateur. Allergènes : la recette ne contient aucun des 14 allergènes à déclarer, mais il faut vérifier la composition des mélanges d'épices (céleri, moutarde possibles) ; signaler l'œuf de la version végétarienne. Éco-gestes : cuisson en grande quantité (énergie économisée), légumes de saison, boîtes réutilisables, pas de gaspillage grâce à la congélation, épluchures au compost, achat en vrac des légumineuses et du riz.

Question 11 – Réalisation, conditionnement et évaluation (4 pts)

Réalisation : viande bien cuite, chili nappant et mijoté, riz cuit et égoutté, oranges pelées à vif et tranchées ; portions à emporter conditionnées et étiquetées ; respect de l'hygiène, du temps et des températures. Évaluation : grille de dégustation ; nombre de jeunes ayant réalisé une étape seuls ; question « De 1 à 5, vous sentez-vous capable de refaire ce plat seul ? », posée en début et en fin d'atelier ; à l'atelier suivant, « Avez-vous mangé votre portion congelée ? L'avez-vous refait ? » ; retour au comité de jeunes pour ajuster la séance suivante.

Barème – Barème du sujet mixte

Temps 1 : indicateurs, efficacité personnelle et limites 4 ; analyse psychosociale et inégalité 3 ; objectifs et plan d'action 5 ; évaluation et budget 3 ; éthique 3 ; expression et sources 2 ; total 20.

Temps 2 : besoins et menu 3 ; bon de commande, fiche technique, apports et version végétarienne 5 ; organisation et animation 4 ; hygiène et éco-gestes 4 ; réalisation et évaluation 4 ; total 20.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

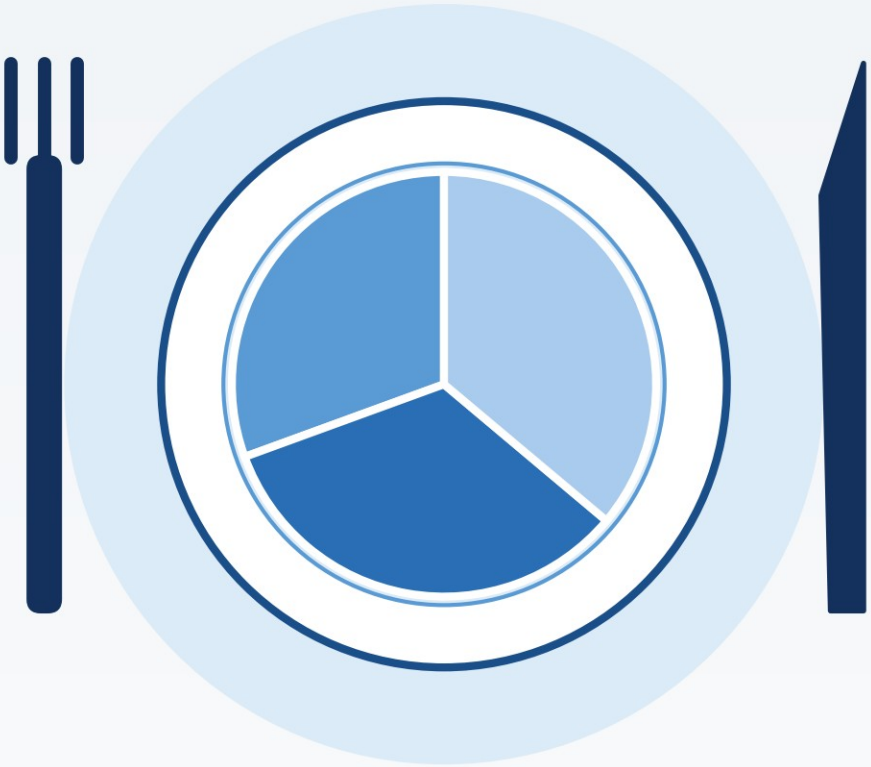
Décider des recettes à la place des jeunes ; organiser des ateliers à des horaires incompatibles avec le travail ; publier des photos de mineurs placés ; demander aux jeunes de parler de leur famille ; oublier les pertes des oranges (30 %) ; oublier le refroidissement rapide et l'étiquetage des portions congelées ; proposer une version végétarienne sans compenser les protéines.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Ce que je sais faire	Sujet	Acquis	En cours	À retravailler
C3.1	Réaliser une analyse prototypique (seuils, quatre zones) et en tirer des messages	S1			
C3.1	Calculer les scores d'une échelle de Likert avec items inversés et les interpréter (Ajzen)	S1			
C3.1	Répartir un public selon les stades de changement et en tirer des conséquences	S1			
C3.1	Analyser une situation avec la socialisation, l'identité, les CPS et l'autodétermination	S2, S3			
C3.1	Justifier chaque action par un concept de psychologie sociale	S1, S3			
C3.1	Formuler des objectifs avec indicateur, cible et échéance ; construire un budget	S1, S3			
C3.2	Établir un bon de commande avec quantités brutes et nettes	S2, S3			
C3.2	Adapter une recette (diabète, mastication, sel, végétarien, halal, studio)	S2, S3			
C3.2	Calculer un apport nutritionnel avec la table Ciqual 2025 et la part des besoins couverte	S2, S3			
C3.2	Animer un atelier qui renforce le sentiment d'efficacité personnelle et l'autonomie	S2, S3			
C3.2	Appliquer l'hygiène (poisson, viande hachée, refroidissement, congélation, allergènes)	S2, S3			
C3.3	Calculer un risque relatif, un intervalle de confiance, une taille d'échantillon ; discuter la causalité	S1			
C3.3	Présenter les limites de l'évocation hiérarchisée et de l'échelle de Likert	S1, S3			
C3.4	Organiser une veille sur les interventions psychosociales	S1			
C3.5	Communiquer sans moraliser avec des jeunes ; adapter les supports à la vue et à l'audition	S1, S2			
C3.6	Réagir à un cyberharcèlement ; protéger le droit à l'image et les données de santé	S1, S3			

Modèles officiels utilisés : structure des sujets U62 (2002-2014) et E5.B (2021-2024) pour le bon de commande, la fiche technique et l'organisation ; BTS blanc CNED E5B pour l'adaptation d'une recette et le calcul nutritionnel ; texte de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024) pour la répartition des compétences entre les deux temps.

DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE



CHAPITRE 4

Pratiques et comportements alimentaires

Mots-clés : Rôles de l'acte alimentaire, Régulation, Pratiques actuelles

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 4 · Pratiques et comportements alimentaires · version normale

1 COURS

Mise en page normale · 96 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 99

2 FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 7 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 100 à 106

3 CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 120 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 107 à 226

4 ANNALES E5

Mise en page normale · 32 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 227 à 258

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 · Cours **4**

4.1 Compétences mobilisées 7

4.2 Croisement référentiel × précisions × indications 7

4.3 Cours 9

4.4 Approfondissements 73

4.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 79

4.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 81

4.7 L'essentiel à retenir 86

4.8 Entraînement 86

4.9 Glossaire 97

4.10 Renvois bibliographiques par notion 98

4.12 Bibliographie numérotée 98

2 · Fiche de révision et fiches-outils **100**

Fiche de révision du chapitre 4 102

1. Les définitions à savoir 102

2. Les rôles de l'acte alimentaire 102

3. Pratiques et vigilance 103

4. Chiffres-clés 103

5. Les pièges 103

6. Auto-test 103

7. Flashcards 103

Compléments du chapitre enrichi 104

Fiches-outils du chapitre 4 104

O4.1 – Recueil des pratiques alimentaires d'un groupe 104

O4.2 – Échelle de la faim et de la satiété 105

O4.3 – Grille d'analyse d'un comportement alimentaire 105

O4.4 – Compatibilité d'une recette avec les pratiques du groupe 105

O4.5 – Repérage et orientation : conduite à tenir 106

3 · Cahier d'exercices **107**

Cahier d'exercices – Chapitre 4 110

Partie 1 – Les rôles de l'acte alimentaire et le comportement alimentaire 111

Partie 2 – La régulation du comportement alimentaire 126

Partie 3 – Les dérégulations : restriction, émotions, troubles du comportement alimentaire 140

Partie 4 – Les déterminants du comportement alimentaire 156

Partie 5 – Évolution des pratiques et pratiques alimentaires actuelles 170

Partie 6 – Les rythmes alimentaires et les âges de la vie 183

Partie 7 – Le comportement alimentaire de l'enfant 196

Partie 8 – Observer, mesurer et agir pour une alimentation durable 208

Bilan : grille d'auto-évaluation 226

4 · Annales E5 ..... **227**

Cahier d'annales E5 – chapitre 4 229

Partie I – Les sujets (sans corrigé) 230

Partie II – Les corrigés détaillés 240

Grille d'auto-évaluation 258

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS

CHAPITRE

04

Pratiques et comportements alimentaires

Rôles de l'acte alimentaire | Régulation | Pratiques actuelles

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

4.1 Compétences mobilisées ... 7

4.2 Croisement référentiel × précisions × indications ... 7

4.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 ... 8

4.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED ... 8

4.3 Cours ... 9

4.3.1 Les rôles de l'acte alimentaire ... 10

4.3.2 Le comportement alimentaire : besoin, oralité, pulsion ... 12

4.3.3 La régulation et la dérégulation du comportement alimentaire ... 13

4.3.4 Les déterminants du comportement alimentaire ... 21

4.3.5 L'évolution des pratiques alimentaires et le syncrétisme culinaire ... 25

4.3.6 Les principales pratiques alimentaires actuelles ... 28

4.3.7 Accompagner l'évolution des pratiques alimentaires ... 34

4.3.8 Les rythmes et la structure des prises alimentaires ... 36

4.3.9 Le développement du comportement alimentaire de l'enfant ... 40

4.3.10 Les comportements alimentaires selon les âges de la vie ... 44

4.3.11 Observer et mesurer les comportements alimentaires ... 49

4.3.12 Vers une alimentation durable : santé et environnement ... 53

4.3.13 Les troubles du comportement alimentaire : comprendre pour prévenir et orienter ... 57

4.3.14 Les stratégies alimentaires des ménages en situation de précarité ... 60

4.3.15 Les pratiques alimentaires religieuses en détail ... 63

4.3.16 La dégustation et l'analyse sensorielle au service de l'éducation ... 66

4.3.17 Repères sur quelques cultures culinaires ... 66

4.3.18 Fil rouge : les pratiques alimentaires des familles des Tilleuls ... 68

4.3.19 Six cas guidés pour s'entraîner à l'analyse d'un comportement alimentaire ... 69

4.4 Approfondissements ... 73

4.4.1 Le goût : un apprentissage ... 73

4.4.2 Manger en pleine conscience et approches non restrictives ... 75

4.4.3 La dimension sociale du repas et la santé ... 75

4.4.4 Le gaspillage alimentaire ... 75

4.4.5 Alimentation et ultra-transformation : comprendre le débat ... 75

4.4.6 Nouveaux aliments et acceptabilité : insectes et substituts végétaux ... 77

4.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 ... 79

4.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles ... 81

4.6.1 Préparer l'oral : défendre une analyse de comportement alimentaire ... 82

4.6.2 Préparer l'atelier culinaire : lire le contexte imposé avec les notions du chapitre ... 83

4.6.3 Dix questions d'entretien pour s'entraîner ... 84

4.7 L'essentiel à retenir ... 86

4.8 Entraînement ... 86

4.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) ... 86

4.8.2 Exercices ... 88

4.8.3 Questions de réflexion ... 91

4.8.4 Étude de cas ... 92

4.8.5 Mises en situation express ... 92

4.8.6 Exercices complémentaires ... 95

4.8.7 Exercices d'approfondissement ... 96

4.9 Glossaire ... 97

4.10 Renvois bibliographiques par notion ... 98

4.12 Bibliographie numérotée..... 98

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- décrire les rôles de l'acte alimentaire (biologique, hédonique, psychologique, social, culturel et identitaire, économique) ;
- définir le comportement alimentaire et les notions de besoin, d'oralité et de pulsion ;
- expliquer la régulation du comportement alimentaire (faim, rassasiement, satiété ; régulation homéostatique et hédonique) et ses dérégulations (restriction cognitive, alimentation émotionnelle, troubles du comportement alimentaire) ;
- identifier les déterminants du comportement alimentaire d'un individu pour construire analyses, conseils et actions éducatives (objectif du guide 2025) ;
- décrire l'évolution des pratiques alimentaires en France et le syncrétisme culinaire ;
- présenter les principales pratiques alimentaires actuelles (végétarisme, flexitarisme, végétalisme, pratiques religieuses, régimes d'exclusion, alimentation durable) et leurs points de vigilance ;
- accompagner l'évolution des pratiques alimentaires sans jugement et en sécurité nutritionnelle.

4.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.1	Comprendre les comportements d'un public pour concevoir des actions éducatives pertinentes	Analyse et diagnostic de situation ; priorités adaptées au contexte
C3.2	Adapter un atelier culinaire aux pratiques du public (végétarisme, religions, budget) et à la régulation (faim, plaisir)	Besoins et spécificités du public identifiés ; qualité organoleptique adaptée
C3.3	Interpréter les données de consommation (INCA, Albane)	Contexte et problématique identifiés
C3.5	Communiquer sans culpabiliser, respecter les choix	Posture professionnelle adaptée

4.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Rôles de l'acte alimentaire	Citer et illustrer les différents rôles	Approche pluridisciplinaire
Définition du comportement alimentaire ; besoin, oralité, pulsion	Définir ; distinguer besoin et envie	Pas de développement psychanalytique
Régulation et dérégulation	Expliquer faim, rassasiement, satiété ; restriction cognitive, alimentation émotionnelle	Physiologie détaillée en BPADN ; TCA : repérage et orientation (BC1)
Déterminants du comportement alimentaire	Analyser les déterminants d'un individu ou d'un groupe	Lien avec le chapitre 2
Évolution des pratiques, syncrétisme culinaire	Décrire les grandes évolutions	S'appuyer sur des données datées (Insee, Crédoc, CNA)
Principales pratiques actuelles	Présenter, repérer les points de vigilance nutritionnelle	Végétarisme, flexitarisme, religions, « sans », durable

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Accompagnement de l'évolution des pratiques	Adopter une posture non jugeante, sécuriser	Recommandations officielles

4.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : bloc 3, savoirs « Pratiques et comportements alimentaires ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 61). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les corrections sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 4.2.2.

Texte	Critère ou indication	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 61	Rôles de l'acte alimentaire ; définition du comportement alimentaire	4.3.1 et 4.3.2
Guide 2025, p. 61	Besoin, oralité, pulsion	4.3.2 (dont l'encadré de vocabulaire)
Guide 2025, p. 61	Régulation et dérégulation des comportements alimentaires	4.3.3 ; 4.3.13 (repérage des TCA)
Guide 2025, p. 61	Déterminants du comportement alimentaire	4.3.4 (société, industrie, médias, genre, PCS) ; 4.3.14 (précarité)
Guide 2025, p. 61	Évolution des pratiques et syncrétisme culinaire ; principales pratiques actuelles	4.3.5 et 4.3.6 ; 4.3.15 et 4.3.17
Guide 2025, p. 61	Accompagnement de l'évolution des pratiques alimentaires	4.3.7 ; 4.3.12 (alimentation durable)
Référentiel, C3.1, C3.2, C3.3, C3.5	Diagnostic, adaptation de l'atelier, données datées, posture	4.3.8 à 4.3.18 ; 4.6

4.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié par rapport au fascicule *Environnement professionnel – Synthèse du cours en bref*, 1re année (CNED 3-6123-AN-WT-00-21), module 2 « Comportements et pratiques alimentaires : déterminants et évolutions » (p. 8 à 24). La psychologie du développement et la sociologie générale (module 5) sont traitées au chapitre 3.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
M2 S1 §1 (p. 8)	Rôles de l'alimentation : points de vue alimentaire, santé, socio-économique	4.3.1
M2 S1 §2 (p. 9 à 11)	Facteurs du comportement : genre (INCA 3), famille, CSP, communication, qualités sensorielles, psychologie	4.3.4 (dont genre et catégorie sociale)
M2 S1 §3 (p. 12)	Prises alimentaires ; faim et satiété ; déterminants de la prise	4.3.3
M2 S1 §4 (p. 13)	Pulsion, besoins nutritionnels, oralité (Abadie)	4.3.2
M2 S2 §1 à §3 (p. 14 à 16)	Famille ; société traditionnelle et société moderne ; mythes et rites	4.3.4 (mangeur hypermoderne, mythes, rites) ; 4.3.5
M2 S2 §4 (p. 16 et 17)	Industrie agroalimentaire, grande distribution, médias	4.3.4 (industrie, distribution, médias)
M2 S2 §5 et §6 (p. 18 et 19)	CSP et classes sociales ; précarité (Wresinski), formes de pauvreté, aide alimentaire, pauvreté et obésité	4.3.4 ; 4.3.14 (précarité, pauvreté, aide alimentaire)

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
M2 S3 §1 (p. 20 et 21)	L'enfant : besoins affectifs, aptitudes motrices, sens, faim et satiété	4.3.9
M2 S3 §2 et §3 (p. 22 et 23)	L'adolescent ; l'adulte (identité, corps, émotions)	4.3.10
M2 S3 §4 (p. 24)	La personne âgée : évolutions physique, sociale, psychique ; syndrome de glissement	4.3.10 (la personne âgée) ; 4.3.11 (dénutrition)

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou était inexact

- **Groupes d'aliments** (p. 8) : le fascicule parle de « 10 groupes et 32 sous-groupes » sans source. La table **Ciqual 2025** (ANSES) classe les aliments en **11 groupes** et plus de 60 sous-groupes ; pour l'éducation, on utilise les repères de Santé publique France (2019).
- **Part de l'alimentation dans les dépenses** (p. 10) : l'étude Insee de 2006 est dépassée. En **2025**, les produits alimentaires et boissons non alcoolisées représentent **12,5 %** de la dépense de consommation des ménages (Insee, 29 mai 2026).
- **Pulsion** (p. 13) : la dopamine et la sérotonine sont des **neurotransmetteurs**, pas des hormones.
- **Grande distribution** (p. 17) : le premier magasin en libre-service a ouvert en France en **1948**, et non en 1950 ; la loi Royer date de 1973 et la crise de la vache folle de 1996.
- **Définition de la précarité** (p. 18) : la citation exacte de Wresinski parle d'« obligations professionnelles, familiales et sociales », et non de « responsabilités élémentaires ».
- **Aide alimentaire** (p. 18) : le PEAD de 1987 a été remplacé par le **FEAD** (2014-2020) puis par le **FSE+** (2021-2027). Les diététiciens interviennent dans de nombreuses structures, pas seulement dans les instances régionales d'éducation et de promotion de la santé.
- **Pauvreté et obésité** (p. 18 et 19) : présenter la nourriture comme une « récompense » propre aux « classes défavorisées » est stigmatisant. Le lien s'explique par les prix, l'offre, le temps, le stress et l'environnement : ce sont des **inégalités sociales de santé**.
- **Lait maternel** (p. 21) : son sucre est le **lactose** (glucose + galactose), pas le glucose seul. Les odeurs de l'alimentation de la mère passent dans le **liquide amniotique**, et non une « barrière plasmatique ».
- **Personne âgée** (p. 24) : l'âge de la retraite (« 62 ans ») n'est pas une définition et a changé depuis ; on retient 60 ou 65 ans selon les sources (OMS, Insee) et 70 ans pour la dénutrition (HAS, 2021).

4.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Repères alimentaires** : les repères en vigueur pour les adultes sont ceux de Santé publique France (2019), fondés sur l'actualisation de l'ANSES (2016) ; l'avis du HCSP de juin 2025 pour le PNNS 5 recommande un seuil maximal pour l'ensemble des viandes (volaille comprise) et des seuils plus bas pour la viande rouge et la charcuterie ; le PNNS 5 (avril 2026) annonce de nouvelles recommandations, pas encore publiées au 26 octobre 2026.
- **Aliments ultra-transformés** : l'ANSES (30 janvier 2025) constate qu'il n'existe pas de définition consensuelle et que les liens avec la santé reposent sur des preuves encore faibles ; le PNNS 5 poursuit l'expertise pour aboutir à une définition opérationnelle et vise à réduire leur consommation de 20 %.
- **Végétarisme et flexitarisme** : l'enquête Ifop pour FranceAgriMer (données 2020, publiée en 2021, 15 000 personnes) reste la plus large enquête publiée ; le CNA (avis n° 90, 2022) a analysé ces nouveaux comportements.

- **Troubles du comportement alimentaire** : les recommandations HAS en vigueur datent de 2010 (anorexie mentale) et de 2019 (boulimie et hyperphagie boulimique).

4.3.1 Les rôles de l'acte alimentaire

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M2 S1 §1 (p. 8)

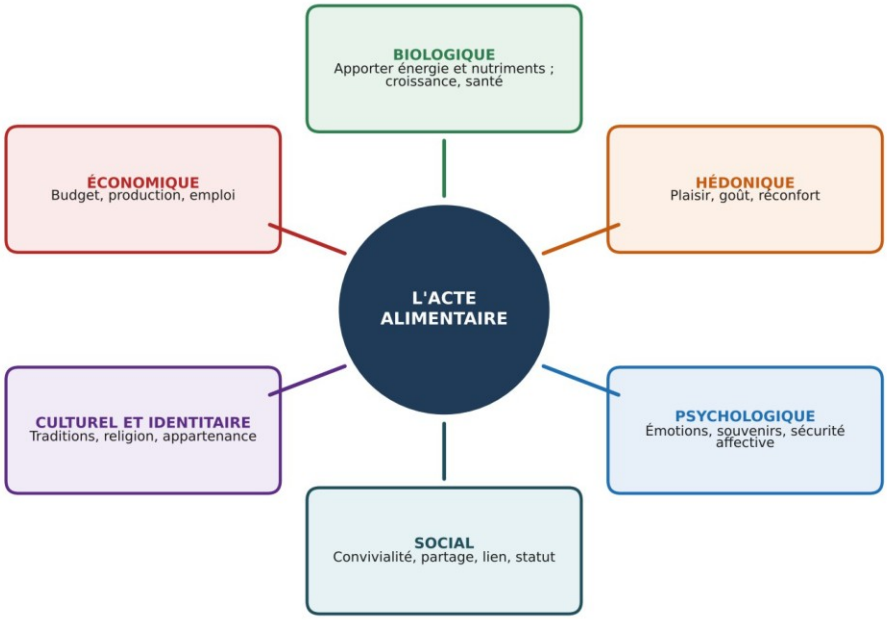


Figure 4.1 – Les rôles de l'acte alimentaire

Comprendre le schéma – Figure 4.1

1. Biologique : couvrir les besoins en énergie, en eau et en nutriments pour la croissance, l'entretien de l'organisme et la santé (BPADN).

2. Hédonique : procurer du **plaisir** par le goût, l'odeur, la texture ; le plaisir n'est pas un « bonus », il participe à la régulation et à l'adhésion aux conseils.

3. Psychologique : réconfort, sécurité affective, souvenirs (« madeleine de Proust »), gestion des émotions.

4. Social : le repas crée et entretient le **lien** (convivialité, partage, hospitalité), structure le temps familial, marque les événements.

5. Culturel et identitaire : l'alimentation exprime l'appartenance à un groupe (région, pays, religion, génération) ; le « repas gastronomique des Français » est inscrit depuis 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité (UNESCO).

6. Économique : budget des ménages, production, emploi, commerce.

7. Conseil professionnel : un message qui ne tient compte que du rôle biologique (« mangez ceci, pas cela ») ignore les cinq autres et a peu de chances d'être suivi.

Repérer les rôles de l'acte alimentaire dans la parole d'un public

Les six rôles ne sont pas une liste à réciter : ils servent à **comprendre** ce que l'alimentation représente pour un public avant de proposer une action. Dans un entretien ou un groupe de parole, chaque phrase révèle souvent un ou deux rôles dominants. Le chapitre 3 (section 3.3.1) présente les regards disciplinaires sur le mangeur ; ici, on apprend à les utiliser pour construire une action.

Ce que l'on entend	Rôle dominant	Ce que cela change pour l'action
« Je mange ce qui me tient au corps jusqu'au soir. »	Biologique	Proposer des repas rassasiants (fibres, protéines), pas des « petites portions »
« Le samedi, c'est pizza devant un film, c'est notre plaisir. »	Hédonique et social	Garder le rituel, l'améliorer (pizza maison, salade) plutôt que l'interdire
« Quand je suis seule, je ne fais pas à manger pour moi. »	Social et psychologique	Travailler sur la convivialité (repas partagés) avant le contenu de l'assiette
« Chez nous, on reçoit avec beaucoup de plats, sinon c'est la honte. »	Culturel et identitaire	Respecter la générosité ; jouer sur la composition des plats, pas sur l'abondance
« Les fruits, c'est trop cher pour nous. »	Économique	Agir sur l'accès et sur des choix à petit prix (fruits de saison, surgelés, compotes)
« Quand je stresse, il me faut du chocolat. »	Psychologique	Ne pas culpabiliser ; travailler la gestion du stress et le plaisir conscient

Méthode pas à pas – Partir des rôles pour construire une action

1. Recueillir la parole du public (entretiens, groupe de parole, questionnaire avec questions ouvertes).

2. Classer chaque élément dans un ou deux rôles ; repérer le ou les rôles **dominants** pour ce public.

3. Repérer les tensions entre rôles : par exemple, le rôle économique (petit budget) peut s'opposer au rôle hédonique (envie de produits de marque pour les enfants).

4. Choisir des actions qui s'appuient sur les rôles dominants au lieu de les combattre : une action qui respecte le plaisir et la convivialité a plus de chances d'être suivie.

5. Vérifier que le rôle biologique reste couvert : l'objectif de santé n'est pas abandonné, il est atteint par un autre chemin.

Exemple – Un même aliment, plusieurs rôles : le gâteau d'anniversaire en crèche

Une crèche veut supprimer les gâteaux d'anniversaire apportés par les familles, jugés trop sucrés. Les rôles en jeu : **social** (fêter ensemble), **culturel** (gâteaux de familles d'origines différentes), **psychologique** (fierté de l'enfant et du parent), **hédonique** (plaisir), **économique** (achat pour le groupe) et **biologique** (sucres). La suppression ne tient compte que du dernier. Une solution respectueuse : garder la fête, une fois par mois pour tous les enfants nés ce mois-là, avec un gâteau maison préparé avec les enfants ou un gâteau apporté par une famille, servi au goûter en part adaptée, avec un fruit.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.1

Dans un foyer de jeunes mères, vous entendez : a) « Je prends des petits pots pour être sûre qu'il ne manque de rien. » b) « Ma grand-mère disait qu'un bébé bien nourri, c'est un bébé bien rond. » c) « Le soir, je mange un paquet de gâteaux quand il s'endort enfin. » d) « On fait un repas toutes ensemble le dimanche, c'est le meilleur moment. » Identifiez le rôle dominant de chaque phrase et indiquez ce qu'il change pour l'atelier que vous préparez.

Corrigé

a) Rôle **biologique** associé à l'anxiété de bien faire (psychologique) : rassurer sur la qualité des repas faits maison, montrer qu'ils couvrent les besoins, sans dévaloriser les petits pots. **b)** Rôle **culturel** (représentation transmise : le poids comme signe de bonne santé) : en parler avec respect et expliquer la régulation de l'enfant (partage des responsabilités, 4.3.9). **c)** Rôle **psychologique** (détente, récompense après une journée difficile) : ne pas juger ; aborder la fatigue et des moments de pause qui ne passent pas uniquement par la nourriture. **d)** Rôle **social** : c'est le levier principal ; l'atelier peut s'appuyer sur ce repas du dimanche pour

cuisiner ensemble.

4.3.2 Le comportement alimentaire : besoin, oralité, pulsion

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M2 S1 §4 (p. 13)

Définition – Comportement alimentaire

Ensemble des **conduites** d'un individu vis-à-vis de l'alimentation : choix des aliments, préparation, nombre et horaires des prises, quantités, lieux et conditions des repas, manière de manger. Il résulte de l'interaction de facteurs **physiologiques** (régulation de la faim et de la satiété), **psychologiques** (émotions, apprentissages, cognition) et **socioculturels** (normes, habitudes, environnement).

Notion	Définition	Exemple
Besoin	Nécessité physiologique d'apports en énergie, en eau et en nutriments ; il se traduit par la faim et la soif	Avoir faim à 12 h après un petit-déjeuner léger
Envie (appétit)	Désir de manger un aliment particulier, orienté par le plaisir, même sans faim	Envie de chocolat en passant devant une boulangerie
Oralité	Ensemble des fonctions de la bouche (succion, déglutition, mastication, goût, langage) ; l'oralité alimentaire se construit de la vie fœtale à l'enfance (tétée, cuillère, morceaux)	Passage aux morceaux vers 8-10 mois ; troubles de l'oralité chez certains enfants prématurés ou en situation de handicap
Pulsion	Poussée interne, peu contrôlée, vers la prise alimentaire, souvent liée à une tension émotionnelle	Manger rapidement de grandes quantités après une journée stressante

L'oralité alimentaire : un développement en plusieurs étapes

L'oralité alimentaire se construit très tôt. On distingue l'**oralité primaire**, réflexe, et l'**oralité secondaire**, volontaire.

Étape	Période	Ce qui se passe
Oralité fœtale	Grossesse	Le fœtus déglutit du liquide amniotique dès la fin du premier trimestre et en perçoit les arômes ; la succion apparaît ensuite
Oralité primaire	Naissance à 4-6 mois environ	Succion-déglutition réflexe, coordonnée avec la respiration ; tétée au sein ou au biberon
Passage à l'oralité secondaire	4 à 8 mois environ	Contrôle volontaire de la bouche ; prise à la cuillère, aliments lisses, puis épais
Mastication	À partir de 8-10 mois, s'affine jusqu'à 3-4 ans	Mouvements de la langue et de la mâchoire, petits morceaux fondants, puis aliments plus fermes

Un **trouble de l'oralité alimentaire** est une difficulté durable à accepter, à manipuler ou à avaler les aliments : haut-le-cœur, refus des morceaux, temps de repas très longs, sélectivité extrême. Il est plus fréquent chez les enfants nés prématurément, ceux qui ont été nourris par sonde ou qui ont des troubles du neurodéveloppement. Le diététicien de santé publique **repère** les signes et **oriente** vers le médecin, qui peut adresser à une équipe spécialisée (orthophoniste formé à l'oralité, psychomotricien).

Attention – Ne pas confondre

- La **néophobie** (refus de l'aliment nouveau, normal entre 2 et 6 ans) se règle avec le temps et l'exposition

répétée (chapitre 3, section 3.4.1).

- Le **trouble de l'oralité** porte sur la capacité à manger (texture, déglutition), pas seulement sur le goût ; il nécessite une prise en charge.
- Le trouble d'évitement et de restriction de l'apport alimentaire (**ARFID**, DSM-5, 2013) associe un évitement important à des conséquences sur la croissance, la nutrition ou la vie sociale (4.5).

Besoin, envie, plaisir : trois moteurs qui se complètent

Le besoin et l'envie ne s'opposent pas : chez une personne en bonne santé, le **plaisir** guide souvent vers ce dont le corps a besoin (envie de salé après un effort, de sucré quand l'énergie baisse). Le plaisir participe aussi à la **régulation** : on s'arrête de manger un plat quand il devient moins agréable (rassasiement sensoriel spécifique, 4.3.3). Le problème apparaît quand l'envie est déclenchée **en permanence** par l'environnement (publicité, disponibilité, portions), sans lien avec la faim, ou quand la **pulsion** sert à apaiser une tension.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.2

Une assistante maternelle vous décrit trois enfants : a) Lina, 9 mois, accepte les purées lisses mais vomit dès qu'il y a un petit grumeau, depuis trois mois. b) Sami, 3 ans, refuse toute nouveauté mais mange volontiers ses plats habituels, variés, et grandit bien. c) Eva, 2 ans, mange avec appétit, puis repousse son assiette au milieu du plat et réclame son yaourt. Pour chaque enfant, indiquez la notion en jeu et la conduite à tenir.

Corrigé

a) Possible **trouble de l'oralité** (réaction aux textures persistante) : en parler aux parents pour qu'ils consultent le médecin, sans forcer les morceaux. **b) Néophobie** normale à cet âge : continuer à proposer les nouveaux aliments sans pression, plusieurs fois, à côté de plats connus. **c) Rassasiement sensoriel spécifique** et écoute de sa faim : comportement normal ; on peut proposer le dessert prévu sans en faire une récompense ni exiger qu'elle finisse le plat.

Attention – Deux précisions de vocabulaire

- L'**oralité** désigne « l'ensemble des fonctions dévolues à la bouche » (Véronique Abadie, pédiatre) : téter, mastiquer, avaler, mais aussi crier, babiller et parler. L'oralité alimentaire et l'oralité verbale se développent ensemble ; un trouble de l'une retentit souvent sur l'autre.
- La **dopamine** (circuit de la récompense) et la **sérotonine** (humeur, satiété) sont des **neurotransmetteurs**, et non des hormones. Une pulsion alimentaire n'est pas un simple « manque de volonté » : elle répond souvent à un besoin de soulagement (ennui, solitude, tension).

4.3.3 La régulation et la dérégulation du comportement alimentaire

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M2 S1 §3 (p. 12)

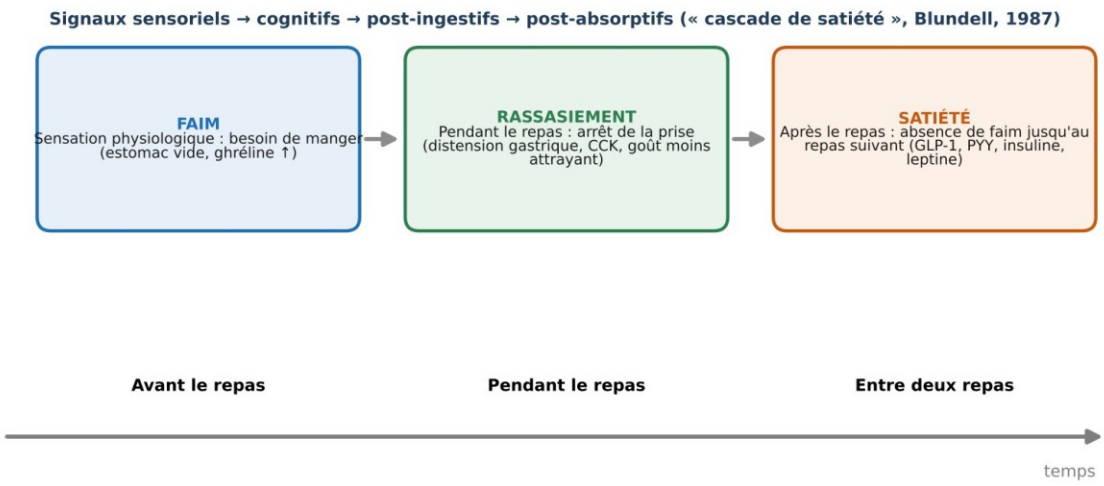


Figure 4.2 – Faim, rassasiement et satiété

Comprendre le schéma – Figure 4.2

1. Faim : sensation physiologique qui pousse à rechercher de la nourriture ; elle s'accompagne de signaux corporels (creux gastrique, baisse d'énergie) et de la sécrétion de **ghréline** par l'estomac.

2. Rassasiement : processus qui se développe **pendant** le repas et conduit à l'**arrêt** de la prise ; il dépend de la distension gastrique, d'hormones intestinales (cholécystokinine, CCK) et de la baisse du plaisir pour un aliment consommé (rassasiement sensoriel spécifique).

3. Satiété : état d'absence de faim **après** le repas, qui détermine le délai jusqu'au repas suivant ; elle dépend des hormones intestinales (GLP-1, PYY), de l'insuline et, à long terme, de la **leptine** sécrétée par le tissu adipeux.

4. Repères temporels : avant, pendant, entre deux repas. Le modèle de la « cascade de satiété » (Blundell, 1987) décrit la succession des signaux sensoriels, cognitifs, post-ingestifs et post-absorptifs.

5. Lien diététique : manger **lentement**, des aliments riches en **fibres** et en **protéines**, sans distraction, favorise le rassasiement et la satiété ; les boissons sucrées rassasient peu.

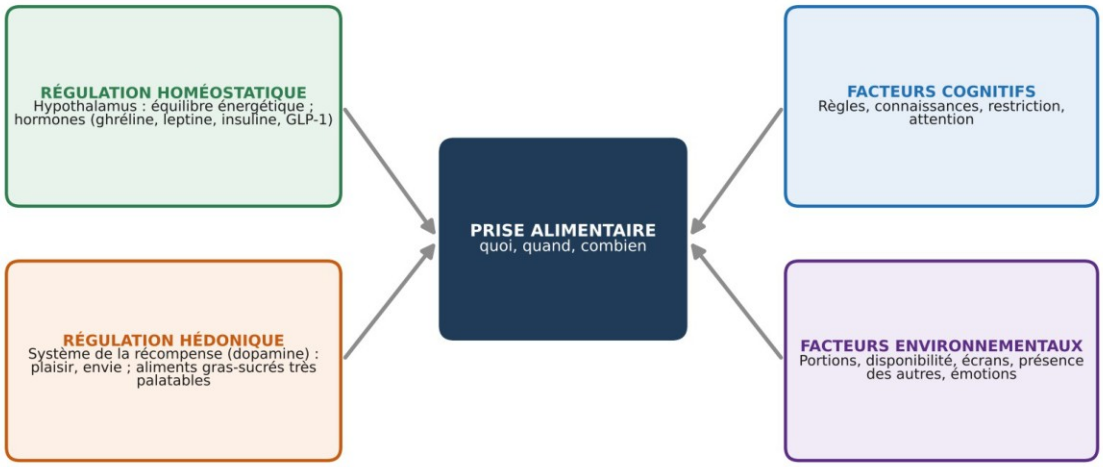


Figure 4.3 – Les systèmes de régulation de la prise alimentaire

Comprendre le schéma – Figure 4.3

1. Régulation homéostatique : l'hypothalamus intègre les signaux hormonaux et nerveux pour maintenir

l'équilibre énergétique (« manger pour vivre »).

2. Régulation hédonique : le système de la récompense (dopamine) pousse à manger pour le **plaisir** ; les aliments très gras et sucrés, très palatables, peuvent prendre le dessus sur les signaux de satiété.

3. Facteurs cognitifs : règles alimentaires, connaissances, attention portée au repas, restriction.

4. Facteurs environnementaux : taille des portions, disponibilité, écrans, présence d'autres personnes, émotions.

5. La prise alimentaire réelle (quoi, quand, combien) résulte de l'**équilibre** entre ces systèmes ; dans un environnement d'abondance, la régulation hédonique et environnementale l'emporte souvent sur les signaux internes.

La cascade de satiété et le pouvoir rassasiant des aliments

John Blundell (1987) a décrit la **cascade de satiété** : après le début d'un repas, plusieurs familles de signaux se succèdent et se superposent pour arrêter la prise puis retarder la suivante.

Signaux	Moment	Exemples	Ce que l'on peut en tirer en éducation
Sensoriels	Pendant le repas, dès les premières bouchées	Goût, odeur, texture ; baisse du plaisir pour l'aliment consommé	Manger lentement, varier les légumes, mastiquer
Cognitifs	Avant et pendant le repas	Ce que l'on croit de l'aliment (« c'est léger », « c'est copieux »), taille perçue de la portion	Un plat présenté comme « copieux » rassasie davantage ; l'attention au repas compte
Post-ingestifs	Dans les minutes qui suivent	Distension de l'estomac, hormones intestinales (CCK, GLP-1, PYY)	Volume, eau et fibres des aliments ; boissons sucrées peu rassasiantes
Post-absorptifs	Dans les heures qui suivent	Nutriments absorbés (glucose, acides aminés), insuline	Les protéines et les fibres prolongent la satiété

Exemple – L'indice de satiété de Holt et collaborateurs (1995)

Des adultes ont mangé des portions de **240 kcal** de 38 aliments, puis ont noté leur faim pendant deux heures. Le pain blanc servait de référence (indice 100). Quelques résultats : pomme de terre bouillie **323**, poisson **225**, porridge **209**, orange **202**, pomme **197**, croissant **47**. À énergie égale, la pomme de terre bouillie a rassasié près de sept fois plus que le croissant (323 / 47 = 6,9).

Leçon : les aliments riches en eau, en fibres ou en protéines, et pauvres en matières grasses, rassasient beaucoup pour peu de calories ; les aliments secs, gras et sucrés rassasient peu. Ces valeurs sont des ordres de grandeur obtenus sur un petit groupe d'adultes.

Définition – Densité énergétique

Quantité d'énergie apportée par 100 g d'un aliment ou d'un repas (kcal pour 100 g). Elle dépend surtout de la teneur en **eau** (qui n'apporte pas d'énergie) et en **lipides** (9 kcal par gramme). Les légumes, les fruits et les soupes ont une faible densité énergétique ; les biscuits, les chips et les produits frits une densité élevée. Les travaux de Barbara Rolls ont montré qu'à volume servi égal, on mange une **masse** d'aliments assez stable : baisser la densité énergétique d'un repas fait baisser l'énergie consommée sans augmenter la faim.

Calcul détaillé – Ce que représentent 100 kcal (Ciqual 2025)

Masse d'aliment qui apporte 100 kcal = 100 / énergie pour 100 g × 100.

- Chips (532 kcal pour 100 g) : 100 / 532 × 100 = **18,8 g** (une petite poignée).

- Biscuit sec (438 kcal) : **22,8 g** (trois à quatre biscuits).
- Pain blanc (287 kcal) : **34,8 g** (une tranche de baguette d'environ 7 cm).
- Pâtes cuites (167 kcal) : **59,9 g** (quelques cuillères).
- Pomme (54 kcal) : **185,2 g** (une grosse pomme).
- Soupe de légumes préemballée (36,8 kcal) : **271,7 g** (un grand bol).
- Carotte crue (30,2 kcal) : **331,1 g** (trois à quatre carottes).

Fibres apportées par ces 100 kcal : chips 18,8 × 4,7 / 100 = **0,88 g** ; carotte 331,1 × 2,9 / 100 = **9,6 g**, soit près de onze fois plus.

Usage en atelier : présenter côte à côte, sur des assiettes, les quantités qui apportent 100 kcal fait comprendre la densité énergétique sans aucun interdit.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.3

Un salarié hésite pour sa collation de 16 h entre un paquet de 30 g de chips (532 kcal pour 100 g), deux biscuits secs de 10 g (438 kcal pour 100 g) et une pomme de 180 g (54 kcal pour 100 g). a) Calculez l'énergie de chaque collation. b) Laquelle rassasiera probablement le plus ? Justifiez avec la cascade de satiété. c) Proposez une collation qui associe plaisir et satiété.

Corrigé

a) Chips : 30 × 532 / 100 = **159,6 kcal** ; biscuits : 20 × 438 / 100 = **87,6 kcal** ; pomme : 180 × 54 / 100 = **97,2 kcal**. **b)** La pomme : pour une énergie voisine de celle des biscuits, elle pèse neuf fois plus (180 g contre 20 g), de l'eau et des fibres ; elle se mâche longtemps (signaux sensoriels) et distend l'estomac (signaux post-ingestifs). Les chips, plus caloriques, rassasient peu. **c)** Par exemple une pomme et un carré de fromage ou une poignée d'amandes (protéines et plaisir), ou un yaourt nature avec un fruit.

Écouter ses sensations : l'échelle de la faim et de la satiété en atelier

L'**échelle de la faim et de la satiété** (fiche-outil O4.2) aide les participants à mettre des mots sur leurs sensations. Une version courante va de **0** (affamé, faible) à **10** (trop plein, inconfort) ; la zone de confort se situe entre 3 (faim nette) et 7 (rassasié, satisfait).

Méthode pas à pas – Animer une séance « faim et satiété »

1. **Introduire** sans parler de poids : « Nous allons apprendre à écouter notre corps pendant un repas. »
2. **Noter** sa faim sur l'échelle avant de commencer (par écrit, de façon individuelle).
3. **Manger lentement** une première moitié du repas, en posant ses couverts, en décrivant les goûts.
4. **Faire une pause** et noter à nouveau : où en suis-je ? ai-je encore faim ou est-ce le plaisir qui me pousse ?
5. **Finir ou s'arrêter** selon la sensation, sans obligation de finir ; noter à la fin.
6. **Échanger** en groupe sur ce que chacun a remarqué, sans juger ce qui a été mangé.

Calcul détaillé – Résultats d'une séance dans un centre social (données fictives)

Douze participants notent leur faim avant le repas, à mi-repas et à la fin. Moyennes : avant **2,5** ; à mi-repas **5,5** ; à la fin **7,0**. Sept participants sur douze ont laissé une partie de leur assiette parce qu'ils étaient « bien », soit 7 / 12 × 100 = **58,3 %**. Avant la séance, au questionnaire d'accueil, 9 sur 12 (**75,0 %**) déclaraient « toujours finir leur assiette ».

- Progression entre l'avant et la fin : 7,0 − 2,5 = **4,5 points**, dont 5,5 − 2,5 = **3,0 points** dès la première moitié du repas, soit 3,0 / 4,5 × 100 = **66,7 %** de la progression.

Lecture : les deux tiers du rassasiement ressenti sont atteints à mi-repas ; la pause permet à plusieurs participants de s'arrêter sans frustration. Ce sont des résultats d'un seul groupe, sans comparaison : ils montrent une prise de conscience, pas un changement durable.

Attention – Un outil d'écoute, pas un outil de contrôle

L'échelle ne doit pas devenir une nouvelle règle (« je n'ai pas le droit de dépasser 6 ») : ce serait une autre forme de restriction cognitive. Elle est déconseillée en groupe avec des personnes qui présentent des signes de TCA, pour qui le travail sur les sensations relève d'un accompagnement individuel spécialisé.

Sommeil, écrans et distraction : trois influences sur la régulation

La régulation de la prise alimentaire (faim, rassasiement, satiété) ne dépend pas seulement de ce que l'on mange. Le **sommeil** et l'**attention** portée au repas modifient aussi les signaux de faim et la quantité consommée.

Influence	Ce que montrent les études	Conséquence pour l'éducation
Manque de sommeil	Chez de jeunes hommes en bonne santé, deux nuits de 4 heures, comparées à deux nuits de 10 heures, ont fait baisser la leptine d'environ 18 %, augmenter la ghréline d'environ 28 % et la faim d'environ 24 %, avec une envie accrue d'aliments riches en glucides (Spiegel et collaborateurs, 2004)	Parler du sommeil dans une action sur l'alimentation, surtout chez les adolescents et les travailleurs de nuit
Repas devant un écran	Une méta-analyse (Robinson et collaborateurs, 2013) montre que manger en étant distrait augmente un peu la quantité mangée pendant le repas, et davantage celle mangée **plus tard** ; à l'inverse, se souvenir de son repas diminue la prise suivante	Encourager le repas sans écran, non comme une règle, mais comme un moyen de mieux sentir sa faim et son plaisir
Repas rapide	Manger vite laisse moins de temps aux signaux de rassasiement (4.3.3)	Prévoir un temps de repas suffisant (au moins 20 à 30 minutes assis en restauration scolaire)

À retenir – Les durées de sommeil recommandées

La National Sleep Foundation (Hirshkowitz et collaborateurs, 2015) recommande **9 à 11 heures** de sommeil de 6 à 13 ans, **8 à 10 heures** de 14 à 17 ans et **7 à 9 heures** de 18 à 64 ans. Chez l'adolescent, l'endormissement se décale naturellement plus tard le soir, alors que les horaires scolaires restent fixes : le manque de sommeil en semaine est fréquent.

Calcul détaillé – La dette de sommeil d'un lycéen (données fictives)

Un lycéen de 16 ans s'endort vers 0 h 20 en semaine et se lève à 6 h 30.

- Durée de sommeil : de 0 h 20 à 6 h 30 = **6 h 10** par nuit.
- Écart avec la recommandation (8 à 10 heures) : 8 h − 6 h 10 = **1 h 50** au minimum, et jusqu'à 10 h − 6 h 10 = **3 h 50**.
- Sur cinq nuits de semaine : 1 h 50 × 5 = 9 h 10, soit **plus de 9 heures** de sommeil en moins au minimum, l'équivalent d'une nuit complète.

Interprétation : ce lycéen risque d'avoir plus faim, surtout d'aliments sucrés et gras, et moins faim le matin ; il saute souvent le petit-déjeuner (4.3.8). Une action sur les rythmes alimentaires des lycéens gagne à aborder aussi le sommeil et les écrans le soir, sans culpabiliser.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.4

Une mère explique : « Mon fils de 11 ans mange son goûter devant sa console, puis il réclame encore à manger avant le dîner et il n'a plus faim à table. » a) Quelles notions du chapitre expliquent cette situation ? b) Proposez trois conseils à la famille. c) Formulez un conseil sans interdiction.

Corrigé

a) La **distraction** pendant le goûter empêche de percevoir le rassasiement et fait manger plus ensuite (Robinson et collaborateurs, 2013) ; le goûter est devenu un **grignotage** prolongé, sans heure fixe ; l'enfant arrive au dîner sans faim, ce qui perturbe le **rythme** des prises (4.3.8). **b)** Un goûter à heure fixe, assis à table, composé par exemple de pain, d'un produit laitier et d'un fruit ; la console seulement après le goûter ; un dîner à heure régulière, sans écran, avec des plats qu'il aime. **c)** « Et si on prenait le goûter ensemble dans la cuisine avant la console ? Tu profiteras mieux de ton jeu ensuite, et tu auras faim pour le dîner. »

Les dérégulations

Définition – Restriction cognitive (Herman et Polivy, 1975)

Intention de **contrôler** son alimentation par des règles mentales (interdits, calculs, horaires imposés) plutôt que par les **sensations** de faim et de satiété, dans le but de maigrir ou de ne pas grossir. Elle fragilise la régulation : la personne perd ses repères internes, alterne contrôle et « craquages » (effet de **désinhibition**) et s'expose à une prise de poids à long terme.

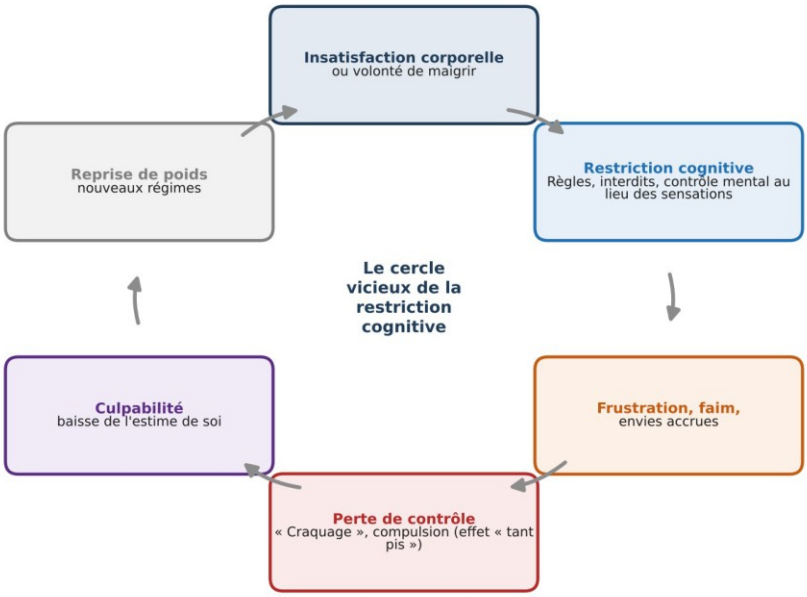


Figure 4.4 – Le cercle vicieux de la restriction cognitive

Comprendre le schéma – Figure 4.4

1. Le point de départ est souvent l'**insatisfaction corporelle** ou une volonté de maigrir (normes de minceur, conseils d'entourage, réseaux sociaux).
2. La **restriction cognitive** remplace les sensations par des règles (« pas de pain le soir », « pas plus de 1 200 kcal »).
3. Elle génère **frustration**, faim et envies accrues pour les aliments interdits.
4. Survient une **perte de contrôle** (« craquage », effet « tant pis, j'ai craqué, autant tout manger »).

5. Elle entraîne **culpabilité** et baisse de l'estime de soi.
6. Puis une **reprise de poids** et de nouveaux régimes, qui relancent le cycle (« effet yo-yo »).
7. Prévention : ne pas prescrire de régimes restrictifs non justifiés, réhabiliter les sensations alimentaires et le plaisir, ne pas classer les aliments en « interdits » (prévention quaternaire, chapitre 1).

Dérégulation	Description
Alimentation émotionnelle	Manger en réponse à des émotions (stress, tristesse, ennui, joie) plutôt qu'à la faim
Externalité (Schachter, 1968)	Manger en réponse à des signaux extérieurs (vue, odeur, heure, portion servie) plutôt qu'aux signaux internes
Grignotage	Prises répétées, hors repas, de petites quantités, sans faim, souvent automatiques
Compulsion	Envie irrésistible de manger un aliment, suivie d'une prise rapide, souvent associée à la culpabilité
Troubles du comportement alimentaire (TCA)	Troubles psychiatriques définis par des critères diagnostiques (DSM-5) : anorexie mentale (restriction, peur de grossir, poids bas), boulimie (crises suivies de comportements compensatoires), hyperphagie boulimique (crises sans compensation), ARFID (restriction ou évitement sans préoccupation pour le poids)

Attention – Le rôle du diététicien face aux TCA en santé publique

En action collective, le diététicien ne **diagnostique** pas et ne prend pas en charge un TCA. Il **prévient** (messages non stigmatisants, pas de régimes, valorisation des sensations et du plaisir), **repère** des signes d'alerte et **oriente** (médecin, structures spécialisées, lignes d'écoute). La prise en charge est pluridisciplinaire (médecin, psychiatre ou psychologue, diététicien formé) et relève du soin (BC1). La HAS a publié des recommandations sur l'anorexie mentale (2010) et sur la boulimie et l'hyperphagie boulimique (2019).

À vous de jouer – Exercice d'application 4.5

Identifiez le phénomène décrit : a) « Je mange toujours tout ce qu'on me sert, même si je n'ai plus faim. » b) « Quand je suis stressée par le travail, je finis le paquet de biscuits. » c) « Je ne mange jamais de pain ni de pâtes, puis le week-end je craque sur tout. » d) « Au bout de quelques cuillères, le gâteau m'a semblé moins bon et j'ai eu envie de fromage. »

Corrigé

a) Externalité (réponse à la portion servie, signal extérieur) et faible écoute du **rassasiement**. **b) Alimentation émotionnelle** (réponse au stress). **c) Restriction cognitive** suivie de **désinhibition** (cercle vicieux). **d) Rassasiement sensoriel spécifique** : le plaisir diminue pour l'aliment consommé, mais reste intact pour un autre aliment ; c'est un mécanisme normal qui favorise la variété (et qui explique qu'on ait « encore de la place pour le dessert »).

Trois styles alimentaires : restreint, émotionnel, externe

Le questionnaire néerlandais du comportement alimentaire (*Dutch Eating Behaviour Questionnaire*, **DEBQ**, van Strien et collaborateurs, 1986) mesure trois styles alimentaires issus de trois théories. Il est utilisé en recherche et en soin ; il ne sert pas à « classer » les participants d'un atelier, mais il aide à comprendre les mécanismes.

Style	Théorie d'origine	Ce qui déclenche la prise	Piste éducative
Restreint	Restriction cognitive (Herman et Polivy, 1975)	Les règles, puis leur rupture (désinhibition)	Réhabiliter les sensations et le plaisir, sortir des interdits
Émotionnel	Théorie psychosomatique (Hilde Bruch, années 1960-1970) : confusion entre faim et émotions apprise tôt	Les émotions négatives (stress, tristesse, colère, ennui), parfois positives	Reconnaître ses émotions, trouver d'autres réponses (CPS, chapitre 3, section 3.3.5)
Externe	Théorie de l'externalité (Schachter, 1968)	Les signaux extérieurs : vue, odeur, heure, portion, publicité	Aménager l'environnement : portions, rangement, écrans, courses

Exemple – L'expérience de l'horloge truquée (Schachter et Gross, 1968)

Des étudiants restent dans une pièce avec une horloge qui avance ou retarde. Quand l'horloge indique faussement l'heure du dîner, les étudiants en surpoids mangent davantage de biscuits mis à disposition que lorsqu'elle indique une heure plus précoce ; les étudiants de poids normal sont moins influencés. Cette expérience a fondé la notion d'**externalité**. Les travaux ultérieurs ont montré que la sensibilité aux signaux externes existe à tous les poids : c'est un mécanisme général, renforcé par un environnement d'abondance.

Attention – Le débat sur l'« addiction alimentaire »

Certains aliments très gras et très sucrés activent fortement le système de la récompense, et certaines personnes décrivent une perte de contrôle proche d'une dépendance. Une échelle de recherche a été construite (*Yale Food Addiction Scale*, Gearhardt et collaborateurs, 2009). Mais l'« addiction alimentaire » n'est **pas** un diagnostic reconnu par le DSM-5 et son existence fait débat. En santé publique, on évite de présenter un aliment comme une « drogue » : cela renforce la peur, la culpabilité et les interdits, donc la restriction.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.6

Pour chaque situation, indiquez le style alimentaire dominant et une piste d'action : a) « Je ne mange jamais de pâtes le soir, mais le week-end, je me rattrape. » b) « Dès que je passe devant la boulangerie, j'achète un croissant. » c) « Les soirs de dispute, je vide le placard. » d) « Au cinéma, je prends le grand pot de pop-corn parce qu'il est en promotion. »

Corrigé

a) Restreint (règle puis désinhibition) : réintroduire les pâtes le soir en quantité adaptée, sans interdit. **b) Externe** (signal visuel) : changer d'itinéraire ou prévoir une collation à emporter si c'est la faim ; sinon, accepter le croissant de temps en temps, sans culpabilité. **c) Émotionnel** : reconnaître l'émotion, chercher une autre réponse (sortir marcher, appeler quelqu'un), en parler si cela devient fréquent. **d) Externe** (taille de portion et prix) : choisir le petit pot, ou partager le grand ; c'est aussi un argument pour réglementer les promotions sur les grandes portions.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.3.1 à 4.3.3 – Rôles, comportement, régulation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six rôles de l'acte alimentaire.
2. Distinguez besoin et envie.
3. Placez dans le temps la faim, le rassasiement et la satiété, avec une hormone pour chacun.
4. Qu'est-ce que le rassasiement sensoriel spécifique ?

5. Définissez la restriction cognitive en citant les auteurs.

6. Pourquoi une pomme de terre bouillie rassasie-t-elle plus qu'un croissant à énergie égale ?

Corrigé – Point d'étape 4.3.1 à 4.3.3

1. Biologique, hédonique, psychologique, social, culturel et identitaire, économique.

2. Le besoin est une nécessité physiologique qui se traduit par la faim et la soif ; l'envie est le désir d'un aliment particulier, orienté par le plaisir, même sans faim.

3. Faim avant le repas (ghréline) ; rassasiement pendant le repas (CCK, distension gastrique) ; satiété après le repas (GLP-1, PYY, insuline ; leptine à long terme).

4. La baisse du plaisir pour un aliment que l'on mange, alors que le plaisir reste intact pour un autre aliment.

5. Herman et Polivy (1975) : intention de contrôler son alimentation par des règles mentales plutôt que par les sensations, pour maigrir ou ne pas grossir.

6. Elle contient beaucoup d'eau et d'amidon et peu de lipides : sa densité énergétique est faible, son volume grand ; indice de satiété 323 contre 47 (Holt et collaborateurs, 1995).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

4.3.4 Les déterminants du comportement alimentaire

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M2 S1 §2 (p. 9 à 11) ; Synthèse M2 S2 §1 à §3 (p. 14 à 16) ; Synthèse M2 S2 §4 (p. 16 et 17) ; Synthèse M2 S2 §5 et §6 (p. 18 et 19)

Déterminant	Exemples	Levier éducatif
Biologiques et sensoriels	Préférence innée pour le sucré et le salé, aversion initiale pour l'amer ; âge ; génétique (sensibilité à l'amertume) ; état de santé ; médicaments	Exposition répétée, éducation sensorielle, adaptation des textures
Psychologiques	Émotions, stress, apprentissages (conditionnement : aliment associé à une maladie ou à une fête), représentations, image du corps	Gestion des émotions, CPS, déculpabilisation
Cognitifs	Connaissances, croyances, règles, attention, littératie	Information adaptée, pensée critique
Sociaux et culturels	Famille, pairs, normes, religion, culture d'origine, genre	Implication de la famille, valorisation des cultures
Économiques	Revenus, prix, budget alimentaire	Recettes à petit prix, accès aux aides
Environnementaux	Offre disponible, taille des portions, marketing, écrans, temps disponible, équipement	Nudges, aménagement de l'environnement, recettes rapides

Définition – Environnement obésogène

Environnement qui favorise la consommation excessive d'énergie et la sédentarité : grande disponibilité d'aliments très palatables et bon marché, portions de grande taille, marketing omniprésent, déplacements motorisés, écrans. Dans cet environnement, maintenir un poids stable demande un effort constant : c'est un

argument pour agir sur l'environnement et non sur la seule responsabilité individuelle.

Exemple – L'effet de la taille des portions

De nombreuses expériences montrent que plus la portion servie (ou le contenant) est grande, plus on mange, sans augmentation proportionnelle de la sensation de satiété. En restauration collective et en atelier, servir des portions adaptées, utiliser des assiettes de taille raisonnable et permettre de se resservir à la demande respecte mieux la régulation que l'obligation de finir l'assiette.

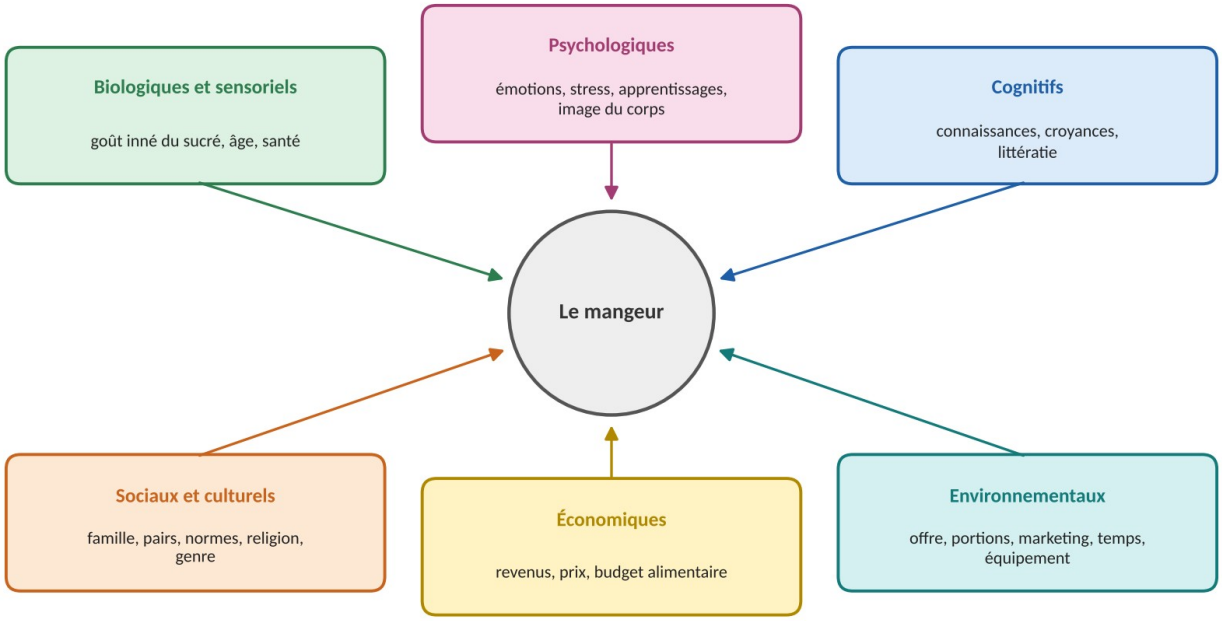


Figure 4.4 bis – Les six familles de déterminants du comportement alimentaire

Comprendre le schéma – Figure 4.4 bis

1. Au centre, **le mangeur** : ses choix résultent de six familles de déterminants qui agissent en même temps.
2. En haut, les déterminants **individuels** : biologiques et sensoriels (goût inné du sucré, âge, santé), psychologiques (émotions, stress, apprentissages, image du corps), cognitifs (connaissances, croyances, littératie).
3. En bas, les déterminants **collectifs** : sociaux et culturels (famille, pairs, normes, religion, genre), économiques (revenus, prix, budget alimentaire), environnementaux (offre, portions, marketing, temps, équipement).
4. Une action qui ne vise que les connaissances (cognitifs) agit sur une seule des six familles : c'est pourquoi l'information seule change peu les comportements.

Du mangeur à son environnement : le modèle socio-écologique

Mary Story et ses collaborateurs (2008) ont proposé un **modèle socio-écologique** des choix alimentaires, qui range les déterminants en quatre niveaux emboîtés. Il prolonge, pour l'alimentation, le modèle des déterminants de la santé de Dahlgren et Whitehead (chapitre 2, section 2.3.1).

Niveau	Exemples de déterminants	Exemples d'actions
Individuel	Goûts, connaissances, compétences culinaires, motivation, revenus, temps	Ateliers culinaires, éducation sensorielle, développement des CPS
Environnement social	Famille, amis, collègues, normes du groupe, modèles	Repas partagés, implication des familles, pair-éducation

Niveau	Exemples de déterminants	Exemples d'actions
Environnement physique	Offre à la maison, à l'école, au travail, dans le quartier ; prix ; portions	Menus de la restauration collective, fontaines à eau, aménagement des selfs, épiceries solidaires
Macro-environnement	Normes culturelles, marketing, politiques agricoles et alimentaires, réglementation	Encadrement de la publicité pour les enfants, loi EGalim, Nutri-Score, taxes sur les boissons sucrées

Lien diététique – Agir à plusieurs niveaux à la fois

Les actions les plus efficaces combinent plusieurs niveaux : un atelier culinaire (individuel) a plus d'effet si les participants repartent avec un panier de légumes à petit prix (environnement physique) et si leurs proches sont invités à la dégustation (environnement social). Les déterminants commerciaux (marketing, prix, formulation des produits) sont présentés au chapitre 2 ; les leviers psychosociaux (normes, engagement, nudges) au chapitre 3.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.7

Classez dans les quatre niveaux du modèle socio-écologique les éléments suivants, relevés pour des collégiens : a) le distributeur de boissons de la piscine municipale ; b) l'envie d'imiter un influenceur sportif ; c) le goût pour les frites ; d) la publicité pour des céréales pendant un dessin animé ; e) les amis qui vont à la boulangerie à la sortie ; f) le menu végétarien hebdomadaire de la cantine. Proposez une action pour le niveau le moins pris en compte par les projets scolaires habituels.

Corrigé

Individuel : c) le goût pour les frites ; b) l'envie d'imiter un influenceur (motivation individuelle, influencée par le macro-environnement des réseaux sociaux). **Environnement social** : e) les amis. **Environnement physique** : a) le distributeur ; f) le menu de la cantine. **Macro-environnement** : d) la publicité, et le cadre des réseaux sociaux. Le niveau le moins travaillé est souvent l'environnement physique hors de l'école : on peut proposer à la mairie d'installer une fontaine à eau et de remplacer une partie des produits du distributeur de la piscine par des fruits secs, des compotes et de l'eau.

Le temps, l'équipement et les compétences : des déterminants souvent oubliés

Les messages nutritionnels supposent souvent que chacun dispose d'une cuisine équipée, de temps et de savoir-faire. Ce n'est pas le cas de nombreux publics : personnes hébergées à l'hôtel social ou chez un tiers, étudiants en studio avec une seule plaque, travailleurs aux horaires morcelés, personnes âgées qui ne peuvent plus se tenir debout longtemps. Ces contraintes relèvent des déterminants **environnementaux** (équipement, temps) et **cognitifs** (compétences culinaires).

Contrainte	Conséquence fréquente	Adaptation d'un conseil
Pas de four, une seule plaque	Plats en une casserole, peu de légumes cuisinés	Recettes « une casserole » ou sans cuisson : pâtes et légumes cuits ensemble, salades composées, légumineuses en conserve
Pas de réfrigérateur ou très petit	Achats au jour le jour, produits secs ou en conserve	Conserves de légumes et de poisson, fruits qui se gardent (pommes, bananes), lait UHT
Peu de temps après le travail	Plats préparés, livraisons	Cuisine en avance le week-end, congélation en portions, recettes de moins de 20 minutes

Contrainte	Conséquence fréquente	Adaptation d'un conseil
Compétences culinaires limitées	Répertoire de quelques plats	Ateliers progressifs, recettes illustrées en images, gestes de base (éplucher, cuire un légume, faire une sauce)

Calcul détaillé – Le temps de la cuisine dans une semaine (données fictives)

Une mère seule qui travaille de 8 h à 17 h 30 dispose, d'après son agenda, de 45 minutes par soir en semaine et de 2 heures le dimanche pour la cuisine.

- Temps disponible par semaine : 5 × 45 + 120 = 225 + 120 = **345 minutes**, soit 345 / 60 = **5 h 45**.
- Si elle prépare le dimanche, en 2 heures, une grande soupe et un plat de légumineuses pour 3 soirs, il lui reste 3 soirs × 45 min = 135 minutes en semaine pour des plats rapides, et deux soirs libres.
- Si chaque dîner « tout maison » demande 60 minutes, il lui faudrait 5 × 60 = **300 minutes** en semaine, alors qu'elle n'en a que 225 : l'objectif est **irréaliste** de 75 minutes.

Lecture : un conseil réaliste s'appuie sur l'organisation (cuisine en avance, portions congelées) plutôt que sur l'injonction à « tout faire maison ».

De la société traditionnelle au mangeur hypermoderne

	Société traditionnelle (avant l'industrialisation)	Société hypermoderne
Priorité	Le groupe : on reproduit ce que faisaient les parents	L'individu : on choisit, et on est responsable de ses choix
Temps	Rythmé par les saisons, les cloches, l'école, l'usine	Contrôlé par chacun, vécu dans l'urgence
Alimentation	Locale, de saison, choix limité ; le surplus est réservé aux fêtes ; l'enfant mange le menu de la famille	Offre abondante toute l'année ; plats préparés, restauration rapide, repas devant les écrans ; produits spécifiques pour chaque âge
Rôle de l'État	Assurer l'approvisionnement et aider les démunis	L'alimentation devient un enjeu de **santé publique** (PNNS)

Le sociologue François Ascher (*Le Mangeur hypermoderne*, 2005) décrit ce mangeur qui doit sans cesse choisir, avec des règles moins fortes : c'est la **gastro-anomie** de Claude Fischler.

- Un **mythe** est un ensemble de croyances et de représentations idéalisées (« la soupe fait grandir », « les carottes rendent aimable », le « bon vieux temps » des plats mijotés). La publicité utilise souvent ces mythes d'authenticité.
- Un **rite** est une manière d'agir propre à un groupe, qui suit une règle et se répète : l'apéritif ouvre le repas, le café prépare la séparation ; le beurre salé en Bretagne ou l'huile d'olive en Provence sont aussi des rites régionaux. Avant d'écarter un aliment, le diététicien tient compte de l'attachement de la personne à ses rites.

L'industrie, la distribution et les médias

- L'**industrie agroalimentaire** réunit la transformation des matières premières agricoles ; avec la production et la distribution, elle forme une filière majeure de l'emploi et des exportations françaises. Elle conçoit des produits très attirants sur le plan sensoriel, qui favorisent l'achat d'impulsion.
- **Repères de la grande distribution** : premier magasin en libre-service en France en 1948 ; premier hypermarché en 1963 ; loi Royer de 1973 pour encadrer l'ouverture des grandes surfaces ; crise de la « vache folle » en 1996, qui renforce l'intérêt pour l'origine, le bio et les labels.
- Les **médias** et la **publicité** poussent à l'achat : répétition, arguments pseudo-scientifiques, ciblage (notamment des enfants), association du produit à des émotions ou à un statut social. Les émissions culinaires donnent aussi envie de cuisiner.

Genre et catégorie sociale

- **Genre** : selon l'étude INCA 3 (ANSES, 2017), les hommes consomment davantage de viande, de charcuterie et de boissons alcoolisées ; les femmes davantage de fruits, de légumes et de produits laitiers frais, et elles déclarent plus souvent suivre un régime. Les hommes vivant seuls mangent moins de fruits et légumes et plus de produits prêts à consommer.
- **Catégorie sociale** : l'Insee classe les personnes selon la nomenclature des **professions et catégories socioprofessionnelles** (PCS 2020), en six groupes : agriculteurs exploitants ; artisans, commerçants et chefs d'entreprise ; cadres et professions intellectuelles supérieures ; professions intermédiaires ; employés ; ouvriers. Le milieu social influence le budget, les lieux d'achat, le temps consacré aux courses et à la cuisine, et les goûts (Bourdieu, chapitre 3).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.3.4 – Les déterminants

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six familles de déterminants du comportement alimentaire.
2. Définissez l'environnement obésogène.
3. Citez les quatre niveaux du modèle socio-écologique de Story et collaborateurs (2008).
4. Classez « la publicité pour des céréales pendant un dessin animé » dans ce modèle.
5. Pourquoi l'information seule change-t-elle peu les comportements ?
6. Donnez un exemple de déterminant environnemental souvent oublié par les messages nutritionnels.

Corrigé – Point d'étape 4.3.4

1. Biologiques et sensoriels, psychologiques, cognitifs, sociaux et culturels, économiques, environnementaux.
2. Un environnement qui favorise la consommation excessive d'énergie et la sédentarité (offre abondante d'aliments palatables et bon marché, grandes portions, marketing, écrans, déplacements motorisés).
3. Individuel, environnement social, environnement physique, macro-environnement.
4. Macro-environnement (marketing et réglementation).
5. Elle n'agit que sur une famille de déterminants (cognitifs), alors que les choix dépendent aussi du prix, de l'offre, des normes, des émotions et des goûts.
6. Le temps disponible, l'équipement de cuisine (une seule plaque, pas de four), ou l'absence de réfrigérateur.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

4.3.5 L'évolution des pratiques alimentaires et le syncrétisme culinaire

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M2 S2 §1 à §3 (p. 14 à 16)

Le modèle alimentaire français et ses transformations

Le modèle français se caractérise traditionnellement par **trois repas** à heures régulières, pris **à table**, en **commun**, structurés (entrée, plat, fromage ou dessert), avec un temps consacré au repas parmi les plus longs d'Europe (plus de 2 heures par jour en moyenne selon l'enquête Emploi du temps de l'Insee, 2010). Ce modèle reste vivace, mais il se transforme :

- **Baisse de la part de l'alimentation** dans le budget : de 35 % de la consommation des ménages en 1960 à 20 % en 2014 (alimentation, boissons et restauration ; Insee Première n° 1568, 2015). En 2025, les seuls produits alimentaires et boissons non alcoolisées représentent **12,5 %** de la dépense de consommation des ménages (Insee, comptes nationaux, 29 mai 2026).
- **Hausse des produits transformés et des plats préparés**, recul de certains produits bruts (pain, pommes de terre, sucre en morceaux), hausse des produits laitiers frais, des boissons sucrées puis de l'eau en bouteille.
- **Développement de la restauration hors foyer** (restauration collective, restauration rapide, livraison de repas à domicile par plateformes).
- **Individualisation** des prises (repas devant les écrans, horaires décalés, repas pris seul), **snacking** et grignotage, sans disparition du repas familial, qui reste valorisé.
- **Nouvelles attentes** : santé, naturalité (« sans additifs »), origine, bien-être animal, environnement, prix ; défiance envers l'industrie ; recherche de praticité.
- **Inégalités** : ces évolutions touchent différemment les groupes sociaux ; l'inflation alimentaire de 2022-2023 a accentué les arbitrages des ménages modestes.

Le Conseil national de l'alimentation (avis n° 90, 2022) a analysé ces « nouveaux comportements alimentaires » et proposé des actions pour les rendre compatibles avec des systèmes alimentaires durables.

Définition – Syncrétisme culinaire

Combinaison, dans une même pratique ou un même plat, d'éléments issus de **cultures culinaires différentes** : techniques, ingrédients, manières de manger. Il résulte de la mondialisation, des migrations et des échanges (pizza, couscous, sushis, burgers « revisités », cuisine fusion) et de l'acculturation (chapitre 3). Il montre que les cultures alimentaires sont **vivantes** et **en mouvement**.

Lien diététique – Utiliser le syncrétisme en atelier

Proposer des recettes « métissées » (tajine de légumes de saison, dahl aux lentilles vertes du Puy, galettes de sarrasin garnies de légumes rôtis aux épices) permet de valoriser les cultures des participants tout en introduisant des produits locaux et de saison.

Où trouver des données datées sur les pratiques alimentaires

Le guide du BTS demande de décrire les évolutions à partir de **données datées et sourcées**. Le tableau suivant présente les principales sources françaises ; les études nationales elles-mêmes sont présentées au chapitre 17.

Source	Producteur	Ce qu'elle permet de décrire
Enquête Emploi du temps (édition 2010 ; vérifiez la publication d'une édition plus récente)	Insee	Le temps passé à manger et à cuisiner, les horaires, les repas à domicile ou à l'extérieur ; en 2010, 2 h 22 par jour consacrées aux repas (Insee Première n° 1417, 2012)
Enquête Budget de famille ; comptes nationaux	Insee	La part de l'alimentation dans les dépenses des ménages selon le revenu, l'âge, le type de ménage
Étude INCA 3 (2014-2015, publiée en 2017)	ANSES	Les consommations alimentaires et les apports nutritionnels des enfants et des adultes, les lieux et les rythmes des prises
Étude Esteban (2014-2016)	Santé publique France	Les consommations rapportées aux repères, l'état nutritionnel (avec examens)
Enquête sur les comportements et consommations alimentaires en France (CCAF)	Crédoc	Les attitudes, les représentations, les pratiques de consommation et leur évolution

Source	Producteur	Ce qu'elle permet de décrire
Avis n° 90 « Nouveaux comportements alimentaires » (2022)	Conseil national de l'alimentation (CNA)	Une synthèse des évolutions (individualisation, numérique, hors foyer, attentes de durabilité)
Panels de consommateurs	Sociétés d'études privées	Les achats réels des ménages (quantités, prix, lieux d'achat) ; données souvent payantes

Méthode pas à pas – Citer une donnée sur les pratiques alimentaires

1. Le chiffre avec son unité et la population concernée (« 24 % des 15-70 ans »).

2. L'année du recueil des données, qui n'est pas toujours celle de la publication (INCA 3 : recueil 2014-2015, publication 2017).

3. Le producteur et le nom de l'étude (Ifop pour FranceAgriMer, ANSES, Insee).

4. La méthode en quelques mots si elle change l'interprétation (déclaratif ou mesuré, échantillon national ou local).

5. La limite : une donnée de 2010 sur le temps des repas ne dit rien des effets du télétravail et des plateformes de livraison apparus depuis.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.8

Un support d'atelier affirme : « Les Français ne prennent plus le temps de manger, ils mangent tous devant les écrans. » a) Relevez ce qui pose problème dans cette phrase. b) Indiquez la source qui permettrait de vérifier le temps consacré aux repas, et ce qu'elle indiquait en 2010. c) Réécrivez la phrase de façon rigoureuse.

Corrigé

a) Généralisation (« tous ») sans chiffre, sans source ni date ; confusion entre une tendance et une règle. **b)** L'enquête Emploi du temps de l'Insee : en 2010, les Français consacraient **2 h 22** par jour aux repas (Insee Première n° 1417, 2012), ce qui reste élevé par rapport à d'autres pays. **c)** « Selon l'Insee, les Français consacraient en 2010 environ 2 h 20 par jour aux repas ; le repas reste un moment important, même si les repas pris devant un écran ou seuls se développent, surtout chez les jeunes adultes (CNA, avis n° 90, 2022). »

Manger hors du foyer : restauration collective, restauration rapide, livraison

Une part croissante des repas est prise **hors du domicile** ou préparée **hors du domicile** : restauration scolaire et d'entreprise, restauration rapide, vente à emporter, livraison par plateformes. Cette évolution modifie le comportement alimentaire de plusieurs façons.

Évolution	Conséquences possibles	Leviers de santé publique
Restauration collective (école, travail, établissements de santé)	Repas structuré et équilibré si l'offre est de qualité ; dépend des choix et du temps de repas	Grammages et fréquences des plats, menus végétariens, loi EGalim, éducation au goût au restaurant scolaire
Restauration rapide et vente à emporter	Repas souvent denses en énergie, riches en sel et en sucres, pris vite, parfois en marchant	Offre de qualité aux abords des établissements, information sur les menus, partenariats avec les commerçants
Livraison par plateformes	Moins de cuisine à domicile, grandes portions, coût élevé, repas pris seul devant un écran	Compétences culinaires rapides, recettes « aussi rapides qu'une livraison »

Évolution	Conséquences possibles	Leviers de santé publique
Repas pris sur le lieu de travail, au poste	Repas court, peu de pause, grignotage	Salles de pause conviviales, temps de pause protégé

Calcul détaillé – La part des repas hors foyer dans une semaine (données fictives)

Un apprenti de 19 ans note ses 14 déjeuners et dîners d'une semaine : 4 au restaurant d'entreprise, 3 en restauration rapide, 2 livrés au domicile, 5 cuisinés chez lui.

- Repas préparés hors du foyer : 4 + 3 + 2 = **9 sur 14**, soit 9 / 14 × 100 = **64,3 %**.
- Repas cuisinés à domicile : 5 / 14 × 100 = **35,7 %**.
- Dépense : restaurant d'entreprise 4 × 4,20 € = 16,80 € ; restauration rapide 3 × 9,50 € = 28,50 € ; livraison 2 × 16,00 € = 32,00 € ; repas maison 5 × 2,50 € = 12,50 € ; total **89,80 €**. La livraison représente 2 repas sur 14 (14,3 %) mais 32,00 / 89,80 × 100 = **35,6 %** de la dépense.

Lecture : remplacer les 2 livraisons par 2 repas maison ferait économiser 2 × (16,00 − 2,50) = **27,00 €** par semaine, soit environ 108 € sur 4 semaines : un argument concret pour un atelier « plus rapide qu'une livraison ».

Lien diététique – La restauration collective, levier majeur

La restauration collective sert chaque jour plusieurs millions de repas dans les écoles, les entreprises, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux. Elle touche tous les milieux sociaux : améliorer son offre est une action de santé publique **universelle**, qui réduit les inégalités (chapitre 1, universalisme proportionné). Le diététicien y intervient en BC2 (élaboration des menus) et en BC3 (éducation des convives, animations).

4.3.6 Les principales pratiques alimentaires actuelles

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

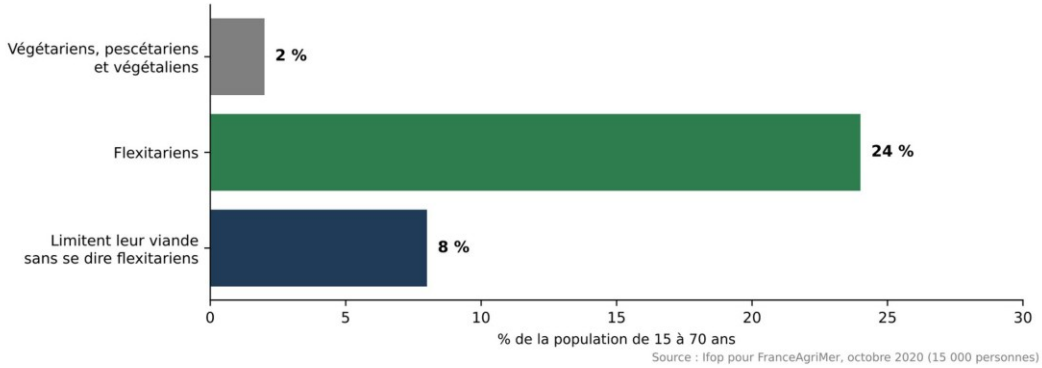


Figure 4.5 – Végétariens et flexitariens en France (2020)

Comprendre le schéma – Figure 4.5

1. Les régimes **sans viande** (végétariens, pescétariens, végétaliens) restent **minoritaires** : environ **2 %** de la population de 15 à 70 ans en 2020.
2. Les **flexitariens** (personnes qui réduisent volontairement leur consommation de viande sans l'exclure) représentent **24 %**.
3. **8 %** limitent leur consommation de viande sans se déclarer flexitariens.
4. Une large majorité déclare penser que l'on consomme trop de viande en France (68 %) ; la réduction de la viande est donc une tendance de fond, en cohérence avec les repères de 2019 et l'avis du HCSP de juin 2025 (seuil maximal pour l'ensemble des viandes, seuils plus bas pour la viande rouge et la charcuterie).

Pratique	Définition	Points de vigilance nutritionnelle
Flexitarisme	Réduction volontaire de la viande, sans exclusion	Peu de risques ; veiller aux apports en fer chez les femmes et adolescentes ; valoriser les légumineuses
Végétarisme (lacto-ovo)	Exclusion de la viande et du poisson ; consommation d'œufs et de produits laitiers	Fer (favoriser la vitamine C au repas), zinc, oméga-3 à longue chaîne, iode ; associer légumineuses et céréales
Pescétarisme	Exclusion de la viande, consommation de poisson	Peu de risques ; attention aux poissons prédateurs (méthylmercure) chez la femme enceinte
Végétalisme / véganisme	Exclusion de tous les produits animaux (le véganisme étend ce refus aux autres usages : cuir, cosmétiques…)	Supplémentation obligatoire en vitamine B12 ; calcium, vitamine D, iode, zinc, fer, oméga-3, protéines ; accompagnement diététique recommandé chez l'enfant, la femme enceinte et la personne âgée
Pratiques religieuses	Halal (islam), casher (judaïsme), interdits ou restrictions (porc, alcool, viande le vendredi, vaches dans l'hindouisme), jeûnes (Ramadan, Carême, jeûnes orthodoxes)	Respect des interdits en restauration collective et en atelier ; adaptation des horaires pendant le Ramadan (hydratation, repas de rupture équilibré) ; exemptions pour les personnes malades
Régimes « sans »	Sans gluten, sans lactose… justifiés médicalement (maladie cœliaque, allergie, intolérance) ou par choix	Hors diagnostic, l'éviction n'apporte pas de bénéfice démontré et peut entraîner des déséquilibres et un surcoût (prévention quaternaire)
Jeûne intermittent, régimes à la mode	Restriction dans le temps ou exclusion de familles d'aliments (cétogène, hyperprotéiné)	Peu de preuves de supériorité à long terme ; risque de restriction cognitive, de carences et de TCA
Alimentation durable	Produits de saison, locaux, bio, moins de viande, moins de gaspillage, moins d'emballages	Cohérente avec la santé ; attention au coût et à l'accessibilité pour les ménages modestes
Aliments ultra- transformés	Formulations industrielles (classification NOVA)	Ils représentent une part importante des apports des Français ; à limiter selon les repères de 2019

Attention – Le Ramadan en pratique

Pendant le mois de Ramadan, les personnes pratiquantes ne mangent et ne boivent pas du lever au coucher du soleil. En atelier ou en restauration collective, on peut proposer des repas à emporter pour la rupture du jeûne, conseiller une **hydratation** suffisante la nuit, un repas d'avant l'aube (suhur) riche en féculents complets et en protéines, et une rupture progressive. Les personnes malades, les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées fragiles sont généralement dispensés selon la religion elle-même : le diététicien n'a pas à juger la pratique, mais à aider à la vivre en sécurité et à orienter en cas de pathologie (diabète : avis médical).

Composer un repas végétarien équilibré

Un repas végétarien équilibré associe, comme tout repas, une **source de protéines**, un **féculent**, des **légumes**, une **matière grasse de qualité** et, selon le repas, un **produit laitier** et un **fruit**. Sans viande ni poisson, deux points demandent une attention particulière : la **qualité des protéines** et l'**absorption du fer**.

Définition – La complémentarité des protéines végétales

Les protéines des **légumineuses** (lentilles, pois chiches, haricots) sont pauvres en acides aminés soufrés

(méthionine) mais riches en lysine ; celles des **céréales** (blé, riz, maïs) sont pauvres en lysine mais mieux pourvues en acides aminés soufrés. Associées dans la journée, elles se complètent et apportent tous les acides aminés indispensables. Les associations traditionnelles l'illustrent : couscous et pois chiches, riz et lentilles (dal), maïs et haricots rouges, pain et houmous.

Calcul détaillé – Un couscous végétarien (Ciqual 2025, une portion)

Composition : semoule cuite 150 g, pois chiches cuits 100 g, carottes cuites 100 g, courgettes cuites 100 g, navets cuits 80 g, huile d'olive 10 g ; dessert : yaourt nature 125 g et une clémentine de 100 g.

- **Énergie** : semoule 246,0 + pois chiches 148,0 + carottes 33,0 + courgettes 15,5 + navets 20,0 + huile 89,9 + yaourt 62,6 + clémentine 45,5 = **660,5 kcal**.
- **Protéines** : semoule 8,71 + pois chiches 8,31 + légumes 2,02 + yaourt 4,79 + clémentine 0,81 + huile 0,03 = **24,7 g**, soit 24,67 × 4 / 660,5 × 100 = **14,9 %** de l'énergie ; la semoule et les pois chiches en apportent ensemble 17,0 g, en association céréale et légumineuse.
- **Fibres** : **20,8 g** (dont 8,2 g pour les pois chiches) ; **calcium** : **365 mg** (dont 171 mg pour le yaourt) ; **fer** : **3,14 mg**, avec **57,3 mg** de vitamine C (dont 49,2 mg pour la clémentine) qui en améliore l'absorption.
- **Lipides** : 17,2 g, soit 17,2 × 9 / 660,5 × 100 = **23,4 %** de l'énergie ; **sel** : 0,48 g sans sel ajouté à la cuisson (il faut ajouter le sel de cuisson et du bouillon).

Lecture : le repas est rassasiant (beaucoup de fibres), apporte des protéines de bonne qualité grâce à l'association semoule et pois chiches, et reste peu coûteux. Le fer est surtout non héminique : la clémentine en fin de repas n'est pas un détail.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.9

Un restaurant scolaire propose comme plat végétarien « pâtes à la sauce tomate et fromage râpé ». a) Ce plat est-il végétarien ? Est-il équilibré ? b) Proposez deux modifications qui en font un plat végétarien complet. c) Citez deux autres associations céréale et légumineuse issues de cuisines du monde.

Corrigé

a) Il est végétarien (sans viande ni poisson), mais pauvre en protéines (le fromage en apporte un peu), en fer et en fibres : c'est un plat « sans viande » plutôt qu'un plat végétarien équilibré. **b)** Ajouter une légumineuse (sauce tomate aux lentilles corail ou haricots rouges) et des légumes (courgettes, poivrons, carottes) ; servir un fruit cru en dessert pour la vitamine C. **c)** Chili sin carne (haricots rouges et riz ou galettes de maïs), dal et riz (Inde), houmous et pain pita (Proche-Orient), riz et pois rouges (Antilles).

Le végétalisme aux périodes sensibles de la vie

Le végétalisme exclut tous les produits animaux. Chez l'adulte en bonne santé, une alimentation végétalienne bien planifiée, avec une **supplémentation en vitamine B12**, peut couvrir les besoins. Aux périodes où les besoins sont élevés ou les réserves faibles, le risque de carences augmente.

Période	Risques principaux	Ce qui est recommandé
Grossesse et allaitement	Carence en vitamine B12 chez la mère et l'enfant allaité (troubles neurologiques du nourrisson), apports en iode, fer, oméga-3 à longue chaîne (DHA), calcium	Suivi médical et diététique, supplémentation en vitamine B12, et selon l'avis médical en iode, DHA, fer, vitamine D

Période	Risques principaux	Ce qui est recommandé
Petite enfance et enfance	Besoins élevés pour la croissance ; carences en vitamine B12, calcium, vitamine D, fer, zinc, iode, DHA ; faible densité énergétique des repas	Le Groupe francophone d'hépatologie, gastroentérologie et nutrition pédiatriques (Lemale et collaborateurs, 2019) souligne ces risques et recommande, si ce régime est choisi, des supplémentations et un suivi médical et diététique régulier ; l'Académie royale de médecine de Belgique (2019) l'a jugé inadapté à l'enfant
Adolescence	Besoins élevés en calcium et en fer ; régimes parfois utilisés pour masquer une restriction (TCA)	Vérifier les motivations sans juger ; suivi, supplémentation en vitamine B12
Personne âgée	Risque de dénutrition protéino-énergétique, sarcopénie, carence en vitamine B12 (absorption déjà diminuée)	Vérifier les apports en protéines et en énergie, supplémentation, suivi

Attention – La place du diététicien de santé publique

Le diététicien ne cherche pas à faire renoncer une famille à ses convictions. Il **informe** sur les risques et les supplémentations indispensables, **sécurise** (repères pratiques, recettes riches en énergie et en protéines végétales) et **oriente** vers le médecin et une consultation diététique individuelle pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Un régime d'exclusion qui apparaît brutalement chez un adolescent, associé à une perte de poids, doit faire rechercher un TCA (4.3.13).

Les régimes d'éviction et les régimes à la mode : faire le point

Pratique	Quand elle est justifiée	Ce que l'on sait quand elle ne l'est pas
Sans gluten	**Maladie cœliaque** (environ 1 % de la population en Europe, diagnostic par le médecin, avec prise de sang et biopsie, **avant** toute éviction) ; allergie au blé ; sensibilité au gluten non cœliaque, encore discutée	Pas de bénéfice démontré pour la santé ou le poids ; produits plus chers, parfois plus gras et sucrés, moins de fibres ; une éviction avant le diagnostic rend celui-ci difficile
Sans lactose	Intolérance au lactose (fréquente chez l'adulte dans le monde, en lien avec la baisse de la lactase)	La plupart des personnes intolérantes supportent environ 12 g de lactose en une prise, soit l'équivalent d'un grand verre de lait, et mieux encore au cours d'un repas (EFSA, 2010) ; les fromages affinés et les yaourts sont souvent bien tolérés ; l'éviction totale réduit les apports en calcium
Jeûne intermittent	Choix personnel ; jeûnes religieux	Les essais comparant la restriction du temps des repas à une alimentation habituelle ou à une simple restriction calorique ne montrent pas de supériorité nette pour la perte de poids (Lowe et collaborateurs, 2020 ; Liu et collaborateurs, 2022) ; risque de restriction cognitive et de compulsions
Régimes cétogènes, hyperprotéinés	Indications médicales précises (certaines épilepsies de l'enfant, sous surveillance)	Peu de preuves à long terme ; exclusion de familles entières d'aliments ; difficiles à tenir ; effet yo-yo

Pratique	Quand elle est justifiée	Ce que l'on sait quand elle ne l'est pas
« Détox », monodiètes, cures de jus	Aucune	Pas de fondement scientifique (le foie et les reins éliminent les déchets) ; restriction sévère, perte d'eau et de muscle

Méthode pas à pas – Répondre à une personne qui suit un régime à la mode

1. **Demander** ce qu'elle en attend et ce qu'elle a remarqué (« Qu'est-ce qui vous a donné envie d'essayer ? »).
2. **Reconnaître** ce qui est positif (attention portée à l'alimentation, envie de cuisiner).
3. **Informer** de façon nuancée, avec des sources, sans ridiculiser.
4. **Vérifier** les risques : enfant, grossesse, maladie, signes de TCA, carences.
5. **Proposer** une alternative compatible avec ses objectifs (plus de légumes, moins de produits ultra-transformés, repas réguliers) et orienter si besoin.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.10

Une mère vous dit : « J'ai supprimé le gluten et le lait pour toute la famille, mes enfants de 4 et 9 ans compris, car j'ai lu que c'était inflammatoire. Personne n'a de maladie. » a) Quels risques nutritionnels pour les enfants ? b) Que lui répondez-vous, en suivant la méthode ? c) Vers qui l'orienter et pourquoi ?

Corrigé

a) Apports insuffisants en **calcium** et en vitamine D (produits laitiers supprimés), en fibres et en énergie si les céréales sont mal remplacées ; surcoût des produits « sans » ; risque de rendre difficile un diagnostic futur de maladie cœliaque. **b)** « Je comprends que vous vouliez protéger la santé de votre famille. Sans maladie diagnostiquée, supprimer le gluten et le lait n'a pas montré de bénéfice, et chez des enfants en croissance, le calcium du lait est important. On peut regarder ensemble comment garder des produits laitiers, par exemple des yaourts et du fromage, et varier les céréales avec du riz, du sarrasin ou du maïs. » **c)** Vers le médecin traitant ou le pédiatre, pour vérifier l'absence de maladie et l'état nutritionnel des enfants, et vers une consultation diététique individuelle si elle maintient l'éviction.

Le jeûne intermittent et les régimes à la mode

De nouvelles pratiques se diffusent rapidement par les réseaux sociaux et les livres grand public. Le diététicien doit pouvoir en parler **sans mépris et sans complaisance** : expliquer ce qu'elles sont, ce que l'on sait de leurs effets, et pour qui elles présentent des risques.

Pratique	Principe	Ce que disent les études	Vigilance
Jeûne intermittent « 16:8 » (alimentation limitée dans le temps)	Manger sur une plage de 8 heures, jeûner 16 heures	Dans un essai de 12 semaines (Lowe et collaborateurs, 2020), pas de perte de poids supérieure à un groupe mangeant sans contrainte horaire ; dans un essai de 12 mois (Liu et collaborateurs, 2022), associer une restriction horaire à une restriction calorique n'a pas fait mieux que la seule restriction calorique	Adolescents, antécédents de TCA, diabète traité, grossesse : à déconseiller ou à encadrer médicalement
Jeûne « 5:2 » ou un jour sur deux	Deux jours par semaine très restreints (environ 500 à 600 kcal), ou alternance	Perte de poids comparable à une restriction continue ; abandon fréquent	Fatigue, irritabilité, compensation les jours libres

Pratique	Principe	Ce que disent les études	Vigilance
Régime cétogène hors indication médicale	Très peu de glucides (moins de 50 g par jour)	Perte de poids rapide au début, en partie d'eau ; peu de données à long terme	Faibles apports en fibres, en fruits, en légumineuses ; utilisé en médecine pour certaines épilepsies, sous surveillance
Cures « détox »	Jus, tisanes, monodiètes	Aucune preuve d'une « élimination de toxines » : le foie et les reins assurent cette fonction	Apports insuffisants, coût élevé, culpabilisation

À retenir – Une position professionnelle

L'ANSES (rapport sur les pratiques alimentaires d'amaigrissement, 2010) a souligné les risques des régimes restrictifs : déséquilibres, perte de masse musculaire, reprise de poids fréquente et **restriction cognitive** (4.3.3). Face à une personne qui pratique un jeûne intermittent, on **écoute** sa motivation (perte de poids, simplicité, effet de groupe), on vérifie l'**absence de situation à risque**, on regarde la **qualité** de ce qui est mangé pendant la plage autorisée et l'impact sur la vie sociale (repas de famille sautés), puis on construit avec elle des repères durables.

Calcul détaillé – Calculer une plage de jeûne

Une étudiante dîne à 20 h 30 et prend son premier repas à 12 h 30 le lendemain.

- Jeûne : de 20 h 30 à minuit = 3 h 30 ; de minuit à 12 h 30 = 12 h 30 ; total : 3 h 30 + 12 h 30 = **16 heures**.
- Plage de prise alimentaire : 24 − 16 = **8 heures** (de 12 h 30 à 20 h 30).
- Comparaison : une personne qui dîne à 20 h et prend son petit-déjeuner à 7 h 30 jeûne déjà **11 h 30** chaque nuit.

Interprétation : la pratique « 16:8 » revient le plus souvent à **supprimer le petit-déjeuner**. Chez une étudiante qui a des cours le matin, il faut vérifier l'effet sur la concentration, le risque de grignotage l'après-midi, et la couverture des besoins en calcium (4.3.10).

À vous de jouer – Exercice d'application 4.11

Un salarié de 45 ans, en bonne santé, vous dit pratiquer le jeûne 16:8 depuis trois mois : « Je me sens bien, et c'est plus simple pour moi. » Il a perdu 2 kg. Son repas de midi est un sandwich et un soda, le soir il mange beaucoup. a) Faut-il lui demander d'arrêter ? b) Que regardez-vous en priorité ? c) Proposez deux conseils qui respectent sa pratique.

Corrigé

a) Non : il est adulte, en bonne santé, la pratique lui convient et ne présente pas de risque identifié pour lui ; on respecte son choix (4.3.7) tout en lui donnant une information juste (pas d'effet supérieur démontré à long terme). **b)** La **qualité** et la **répartition** des apports pendant la plage de 8 heures : un déjeuner pauvre (sandwich et soda) puis un dîner très copieux. **c)** Composer un déjeuner plus complet et rassasiant (féculent, légumes, protéines, fruit, eau à la place du soda) ; prévoir une collation de fin d'après-midi (fruit, yaourt, pain) pour arriver au dîner sans faim excessive et dîner plus légèrement.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.3.5 et 4.3.6 – Évolutions et pratiques actuelles

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Décrivez le modèle alimentaire français traditionnel en trois caractéristiques.
2. Quelle était la part de l'alimentation dans la consommation des ménages en 1960 et en 2014 ?

3. Définissez le syncrétisme culinaire.
4. Distinguez végétarisme, végétalisme et flexitarisme.
5. Quel supplément est obligatoire en cas de végétalisme ?
6. Pourquoi associer légumineuses et céréales ?

Corrigé – Point d'étape 4.3.5 et 4.3.6

1. Trois repas à heures régulières, pris à table, en commun, structurés (entrée, plat, fromage ou dessert).
2. 35 % en 1960 et 20 % en 2014 (Insee, 2015).
3. La combinaison, dans une même pratique ou un même plat, d'éléments issus de cultures culinaires différentes.
4. Végétarisme : ni viande ni poisson ; végétalisme : aucun produit animal ; flexitarisme : réduction volontaire de la viande sans exclusion.
5. La vitamine B12.
6. Leurs protéines se complètent : les légumineuses apportent la lysine qui manque aux céréales, les céréales des acides aminés soufrés qui manquent aux légumineuses.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

4.3.7 Accompagner l'évolution des pratiques alimentaires

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Méthode pas à pas – Cinq principes pour accompagner un changement de pratique

1. Comprendre avant de conseiller : demander à la personne ce qu'elle mange, pourquoi, ce qui compte pour elle (rôles de l'acte alimentaire, valeurs, contraintes).

2. Respecter les choix (végétarisme, religion, culture) et ne pas chercher à les « corriger » ; vérifier seulement la **sécurité nutritionnelle**.

3. Partir de l'existant : proposer de petits changements compatibles avec les habitudes (ajout plutôt que suppression ; remplacement plutôt qu'interdiction).

4. Préserver le plaisir et la convivialité : un conseil qui supprime le plaisir est rarement suivi.

5. S'appuyer sur des repères officiels à jour (Santé publique France, ANSES, HCSP) et sur des sources indépendantes, et orienter vers une consultation lorsque la situation le justifie (pathologie, régime d'exclusion chez l'enfant).

Exemple – Accompagner une famille qui devient végétarienne

Une famille avec deux enfants (6 et 10 ans) décide de devenir végétarienne pour des raisons éthiques. Le diététicien : respecte le choix ; vérifie la présence quotidienne de produits laitiers et d'œufs ; propose des légumineuses plusieurs fois par semaine associées à des céréales ; conseille des sources de fer (légumineuses, céréales complètes) avec de la vitamine C au repas ; recommande des poissons gras si la famille les accepte, sinon de l'huile de colza et des noix pour les oméga-3 ; signale qu'en cas de passage au végétalisme, une supplémentation en vitamine B12 est indispensable et un suivi médical et diététique recommandé pour les enfants.

Recueillir les pratiques sans juger : les questions utiles

Accompagner commence par **comprendre**. Les techniques de communication (questions ouvertes, reformulation, écoute active) sont présentées au chapitre 3 (sections 3.3.8 et 3.3.9) ; voici comment les appliquer aux pratiques alimentaires.

Ce que l'on veut savoir	Question ouverte possible	À éviter
Les habitudes	« Racontez-moi une journée habituelle de repas, du réveil au coucher. »	« Vous prenez bien un petit-déjeuner ? » (question fermée qui induit la réponse)
Le sens d'une pratique	« Qu'est-ce qui compte pour vous dans cette façon de manger ? »	« Pourquoi vous ne mangez pas de viande ? » (le « pourquoi » met sur la défensive)
Les règles religieuses ou culturelles	« Y a-t-il des aliments que vous ne mangez pas ou des périodes particulières ? »	Supposer une pratique à partir du nom ou de l'origine
Les contraintes	« Qu'est-ce qui vous facilite ou vous complique les repas en ce moment ? »	« Il suffit de s'organiser. »
Les envies de changement	« Si vous pouviez changer une seule chose dans vos repas, ce serait quoi ? »	Proposer une liste de changements avant d'avoir écouté

Méthode pas à pas – Vérifier la sécurité nutritionnelle d'une pratique

1. Identifier ce qui est exclu (familles d'aliments, périodes de jeûne).

2. Repérer les nutriments que ces aliments apportent (viande : fer, zinc, B12 ; produits laitiers : calcium ; céréales complètes : fibres, fer).

3. Vérifier si d'autres aliments les remplacent (légumineuses, boissons végétales enrichies, œufs).

4. Évaluer le contexte : âge, grossesse, maladie, budget, signes d'alerte.

5. Décider : conseils collectifs suffisants, ou orientation vers un médecin ou une consultation diététique individuelle.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.12

Transformez en questions ouvertes et non jugeantes : a) « Vous mangez assez de légumes ? » b) « Pourquoi vous donnez des sodas à vos enfants ? » c) « Vous êtes musulman, donc vous ne mangez pas de porc ? » d) « Vous savez qu'il ne faut pas sauter de repas ? »

Corrigé

a) « Quels légumes aimez-vous, et comment les préparez-vous à la maison ? » **b)** « Quelles boissons vos enfants prennent-ils pendant la journée ? Qu'est-ce qu'ils aiment boire ? » **c)** « Y a-t-il des aliments que vous ne mangez pas ? » (posée à tous les participants). **d)** « Comment se passent vos repas dans la journée ? Y a-t-il des moments où vous n'avez pas le temps de manger ? »

Un accompagnement suivi sur trois rencontres

Les cinq principes de l'accompagnement (début de la section) prennent tout leur sens dans la durée. L'exemple suivant, fictif, montre comment un changement se construit **pas à pas**, à partir de ce que la personne veut et peut faire.

Exemple – Mme K., 38 ans, trois enfants, rencontrée dans un centre social (données fictives)

Rencontre 1 – Comprendre. Mme K. vient à la permanence parce que « les enfants mangent trop de gâteaux

». Le diététicien l'écoute : elle travaille en horaires décalés, fait les courses une fois par semaine au supermarché, achète des paquets de gâteaux pour les goûters « parce que c'est pratique », et le repas du soir est souvent pris devant la télévision. Elle tient à ce que les enfants « aient de quoi manger » et à leur faire plaisir. Questions ouvertes : « Comment se passent les goûters à la maison ? » ; « Qu'est-ce qui serait le plus facile à changer pour vous ? ». Elle choisit **un seul objectif** : remplacer les gâteaux du goûter deux jours par semaine.

Rencontre 2 (trois semaines plus tard) – Ajuster. Elle a remplacé les gâteaux le mercredi et le samedi par du pain, du chocolat en tablette et un fruit : « Les petits ont bien aimé, le grand a râlé. » Le diététicien **valorise** l'essai, et cherche avec elle une solution pour le grand (il prépare lui-même son goûter, avec du pain et une pâte à tartiner en petite quantité, ou une banane). Elle décide de passer à **quatre goûters sur sept** et d'essayer un dîner par semaine sans télévision.

Rencontre 3 (deux mois plus tard) – Consolider. Quatre goûters sur sept sont « maison » ; le dîner sans écran du dimanche est devenu « le moment où l'on se raconte la semaine ». Elle signale qu'elle dépense un peu moins en gâteaux. Le diététicien l'aide à anticiper les moments difficiles (vacances scolaires, semaines de nuit) et propose qu'elle témoigne à l'atelier goûters du centre social.

Calcul détaillé – Mesurer le changement

- Goûters « maison » : 0 sur 7 au départ ; 2 sur 7 à la rencontre 2, soit 2 / 7 × 100 = **28,6 %** ; 4 sur 7 à la rencontre 3, soit 4 / 7 × 100 = **57,1 %**.
- Dîners sans écran : 0 sur 7 au départ ; 1 sur 7 ensuite, soit **14,3 %**.

Interprétation : le changement paraît modeste en chiffres, mais il est **choisi**, **réaliste** et **durable** ; il touche aussi le rôle social du repas. Un objectif imposé (« plus aucun gâteau ») aurait sans doute été abandonné en quelques jours.

À retenir – Ce que montre cet exemple

- On part de la **demande** et des **contraintes** de la personne (horaires, budget, goûts des enfants), pas d'un modèle idéal.
- Un **seul objectif** à la fois, choisi par la personne, formulé de façon concrète et mesurable.
- On **valorise** chaque essai, même partiel, et l'on cherche des solutions aux difficultés plutôt que de rappeler la règle.
- On **mesure** avec des indicateurs simples (nombre de jours sur 7) qui parlent à la personne.
- Les techniques d'entretien (questions ouvertes, reformulation, entretien motivationnel) sont détaillées au chapitre 3.

4.3.8 Les rythmes et la structure des prises alimentaires

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Repas, collations et grignotage

Le **rythme alimentaire** désigne le nombre, les horaires et la régularité des prises alimentaires. En France, le modèle des **trois repas** (petit-déjeuner, déjeuner, dîner), complété d'un **goûter** chez l'enfant, reste largement majoritaire, avec des horaires plus synchronisés qu'ailleurs en Europe : vers 13 heures, près de la moitié des Français sont à table (Insee, enquête Emploi du temps 2010).

Prise	Définition	Points de vigilance
Repas	Prise structurée, à heure régulière, souvent assise et partagée	Saut de repas (petit-déjeuner chez les adolescents, déjeuner chez les actifs pressés)

Prise	Définition	Points de vigilance
Collation	Prise prévue, en petite quantité, entre deux repas, répondant à une faim (goûter de l'enfant, collation de la personne âgée ou du sportif)	Collation matinale à l'école non recommandée si l'enfant a pris un petit-déjeuner (avis de l'AFSSA, 2004)
Grignotage	Prises répétées, non structurées, sans faim, souvent automatiques et associées aux écrans	Apport énergétique peu perçu, aliments denses en énergie
Prise nocturne	Prise alimentaire la nuit (travail posté, insomnie, trouble)	Désynchronisation des rythmes ; repérer un éventuel syndrome d'alimentation nocturne

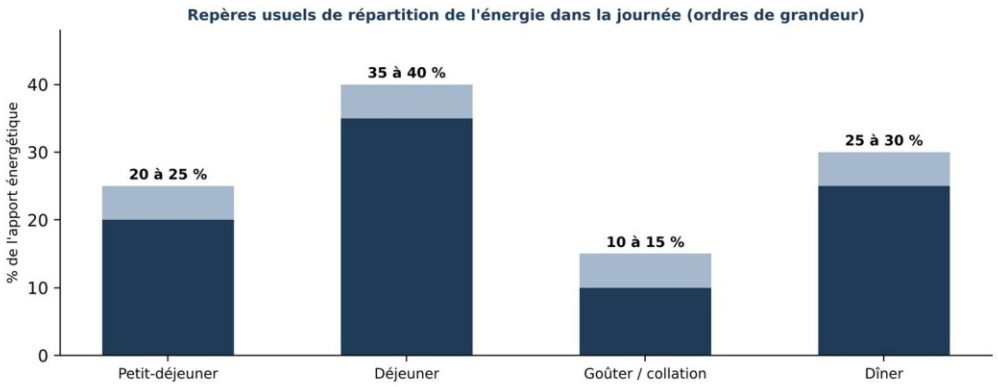


Figure 4.6 – Répartition usuelle de l'énergie dans la journée

Comprendre le schéma – Figure 4.6

1. Les fourchettes présentées sont des **ordres de grandeur** couramment utilisés en restauration collective et en éducation nutritionnelle ; elles ne sont pas des normes strictes et s'adaptent à l'âge, à l'activité, aux habitudes culturelles.
2. Le **petit-déjeuner** (20 à 25 %) et le **déjeuner** (35 à 40 %) apportent ensemble plus de la moitié de l'énergie de la journée.
3. Le **goûter** (10 à 15 %) est une vraie prise chez l'enfant et l'adolescent, en raison de l'écart entre déjeuner et dîner.
4. Le **dîner** (25 à 30 %) gagne à ne pas être le repas le plus copieux, surtout chez les personnes qui ont sauté des repas dans la journée.
5. La **régularité** compte autant que la répartition : elle facilite l'écoute de la faim et de la satiété (4.3.3).

Exemple – Calcul détaillé : répartition de l'énergie d'un adolescent

Un lycéen consomme sur une journée 2 700 kcal : petit-déjeuner 0 kcal (sauté), collation de 10 h (viennoiserie et soda) 520 kcal, déjeuner au self 950 kcal, grignotage de l'après-midi 480 kcal, dîner 750 kcal.

- Vérification : 0 + 520 + 950 + 480 + 750 = **2 700 kcal** . ✓
- Parts : collation de 10 h 520 / 2 700 × 100 = **19,3 %** ; déjeuner 950 / 2 700 = **35,2 %** ; grignotage 480 / 2 700 = **17,8 %** ; dîner 750 / 2 700 = **27,8 %**.
- Prises non structurées (collation de 10 h + grignotage) : 520 + 480 = 1 000 kcal, soit 1 000 / 2 700 × 100 = **37,0 %** de l'énergie.

Interprétation : plus d'un tiers de l'énergie est consommé hors repas, sous forme d'aliments denses en énergie et pauvres en fibres ; le petit-déjeuner sauté est « compensé » par la collation de 10 h. Piste : un petit- déjeuner rapide (lait ou yaourt, pain ou céréales, fruit) d'environ 500 kcal remplacerait la collation de 10 h, et un goûter structuré (pain, fromage, fruit) remplacerait le grignotage, sans augmenter l'apport total.

Le petit-déjeuner : des arguments à nuancer

Le petit-déjeuner est souvent présenté comme « le repas le plus important de la journée ». Les données justifient de le **recommander**, surtout chez l'enfant et l'adolescent, mais sans en faire une obligation.

Ce que l'on observe	Ce que l'on sait aujourd'hui
Dans les études d'observation, sauter le petit-déjeuner est associé à un surpoids plus fréquent et à une alimentation de moins bonne qualité	Une association n'est pas une preuve : les personnes qui sautent le petit-déjeuner ont souvent d'autres habitudes (sommeil court, grignotage, horaires irréguliers)
Chez l'adulte, des essais randomisés ont comparé « prendre » et « sauter » le petit-déjeuner	Pas d'effet net sur la perte de poids (Dhurandhar et collaborateurs, 2014 ; méta-analyse de Sievert et collaborateurs, 2019) ; le petit-déjeuner augmente un peu l'activité physique spontanée le matin (Betts et collaborateurs, 2014)
Chez l'enfant et l'adolescent	Un petit-déjeuner semble favoriser l'attention et la mémoire en fin de matinée, surtout chez les enfants dont l'alimentation est peu satisfaisante (revue d'Adolphus et collaborateurs, 2013) ; il aide à couvrir les besoins en calcium et en fibres

Lien diététique – Ce que l'on conseille

- Chez l'**enfant** et l'**adolescent** : un petit-déjeuner ou, à défaut, une **première prise structurée** avant 10 h (pain, produit laitier, fruit), sans collation sucrée en plus pour ceux qui ont déjeuné (avis de l'AFSSA, 2004).
- Chez l'**adulte** qui n'a pas faim le matin : il n'est pas utile de se forcer ; il vaut mieux prévoir une collation de qualité dans la matinée que d'arriver affamé au déjeuner.
- Partout : privilégier un petit-déjeuner **simple et peu coûteux**, plutôt que des produits très sucrés présentés comme « spécial petit-déjeuner ».

Calcul détaillé – Le coût d'un petit-déjeuner simple (prix fictifs, octobre 2026)

Pour un enfant : 50 g de pain (baguette à 1,10 € les 250 g), 10 g de beurre (2,40 € les 250 g), 200 mL de lait demi-écrémé (1,05 € le litre), une pomme de 150 g (2,40 € le kilo).

- Pain : 50 / 250 × 1,10 = **0,22 €** ; beurre : 10 / 250 × 2,40 = **0,10 €** ; lait : 0,2 × 1,05 = **0,21 €** ; pomme : 0,150 × 2,40 = **0,36 €**.
- Total : 0,22 + 0,10 + 0,21 + 0,36 = **0,89 €**. Avec un fruit de saison moins cher ou une demi-pomme pour un petit, on descend facilement sous 0,75 €.

Lecture : un petit-déjeuner équilibré n'est pas réservé aux familles aisées ; c'est un argument utile dans un atelier en quartier prioritaire.

Rythmes de vie et chrononutrition

L'horloge biologique (rythmes circadiens) influence l'appétit, la sensibilité à l'insuline et le métabolisme. Les travaux sur la **chrononutrition** suggèrent qu'une alimentation concentrée en journée et un dîner léger et pas trop tardif sont plus favorables, et que le **travail posté** ou de nuit augmente le risque de surpoids et de troubles métaboliques. Ces données relèvent encore en partie de la recherche ; en pratique, on conseille surtout **régularité**, **petit-déjeuner** ou première prise structurée, et organisation des repas adaptée aux horaires de travail (chapitre 3, étude de cas des salariés en 3 × 8).

Organiser les repas avec des horaires décalés

Le travail posté (2 × 8, 3 × 8), le travail de nuit et les horaires morcelés (aide à domicile, propreté, transport) désorganisent les rythmes alimentaires : repas sautés, grignotage la nuit, boissons sucrées et café pour tenir. Le principe est de garder **trois prises structurées** sur 24 heures, calées sur le **sommeil** plutôt que sur l'heure.

Poste	Organisation conseillée	Points d'attention
Matin (6 h – 14 h)	Petite collation au réveil (laitage, fruit) ; vraie collation vers 9 h-10 h (pain, fromage) ; déjeuner à la sortie ; dîner léger et pas trop tardif	Ne pas arriver au déjeuner de 14 h à jeun depuis la veille
Après-midi (14 h – 22 h)	Petit-déjeuner normal ; déjeuner complet avant 13 h 30 ; collation vers 18 h ; repas léger au retour	Éviter un repas copieux à 23 h juste avant le coucher
Nuit (22 h – 6 h)	Dîner complet avant la prise de poste (vers 20 h) ; collation légère vers 1 h-2 h (soupe, pain, laitage, fruit) ; petit-déjeuner léger au retour avant de dormir	Éviter les produits gras et très sucrés la nuit ; limiter le café en fin de poste pour préserver le sommeil

Exemple – Les salariés de nuit d'une plateforme logistique

Un service de santé au travail constate que les salariés de nuit grignotent au distributeur entre 2 h et 4 h. Plutôt que de distribuer des conseils écrits, le diététicien travaille avec l'entreprise : salle de pause équipée d'un four à micro-ondes et d'un réfrigérateur, distributeur proposant aussi des soupes, des yaourts et des fruits, pause repas protégée de 30 minutes, atelier « gamelles de nuit » animé sur le temps de travail. Les leviers sont **environnementaux** autant qu'individuels (chapitre 3, cas des salariés en 3 × 8).

À vous de jouer – Exercice d'application 4.13

Une infirmière de nuit (21 h – 7 h) dîne à 19 h, ne mange rien pendant la nuit puis, en rentrant à 7 h 30, prend un grand petit-déjeuner avant de dormir jusqu'à 14 h ; elle déjeune à 15 h et grignote jusqu'à son départ. a) Repérez deux problèmes de rythme. b) Proposez une organisation sur 24 heures avec trois prises structurées et une collation.

Corrigé

a) Un jeûne de plus de 12 heures pendant la nuit de travail, ce qui favorise la fatigue et les malaises vers 3 h-4 h ; un repas copieux juste avant de dormir, qui gêne le sommeil ; un grignotage l'après-midi qui remplace un vrai repas. **b)** 15 h : premier repas complet au réveil ; 20 h : dîner complet avant de partir ; 1 h-2 h : collation légère pendant la pause (soupe, pain, fromage, fruit) ; 7 h 30 : petite prise avant de dormir (laitage et fruit, ou une tartine). La journée garde trois repas et une collation, adaptés au sommeil.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.3.7 et 4.3.8 – Accompagner, rythmes

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les cinq principes pour accompagner un changement de pratique.
2. Transformez en question ouverte : « Vous mangez des légumes ? »
3. Distinguez collation et grignotage.
4. Donnez la répartition usuelle de l'énergie entre les quatre prises de la journée.
5. Que montrent les essais randomisés sur le petit-déjeuner et le poids chez l'adulte ?
6. Pour un poste de nuit, où placer le dîner et la collation ?

Corrigé – Point d'étape 4.3.7 et 4.3.8

1. Comprendre avant de conseiller ; respecter les choix ; partir de l'existant ; préserver le plaisir et la convivialité ; s'appuyer sur des repères officiels et orienter si besoin.
2. « Quels légumes aimez-vous et comment les préparez-vous ? »
3. La collation est prévue, en petite quantité, en réponse à une faim ; le grignotage est fait de prises répétées, non structurées, sans faim.
4. Petit-déjeuner 20 à 25 %, déjeuner 35 à 40 %, goûter 10 à 15 %, dîner 25 à 30 % (ordres de grandeur).
5. Pas d'effet net sur la perte de poids (Dhurandhar et collaborateurs, 2014 ; Sievert et collaborateurs, 2019).
6. Un dîner complet avant la prise de poste (vers 20 h) et une collation légère vers 1 h-2 h.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

4.3.9 Le développement du comportement alimentaire de l'enfant

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · CNED : Synthèse M2 S3 §1 (p. 20 et 21)

De la succion aux morceaux

Âge	Étapes	Rôle de l'entourage
0-6 mois	Succion-déglutition réflexes ; lait maternel ou infantile ; régulation à la demande	Repérer les signes de faim et de satiété ; soutenir l'allaitement
4-6 mois	Début de la diversification (entre 4 mois révolus et 6 mois selon les recommandations de Santé publique France, 2021), purées lisses ; introduction des allergènes sans retard	Proposer, varier, ne pas forcer
6-12 mois	Textures moulinées puis écrasées, petits morceaux fondants vers 8-10 mois ; mastication	Adapter les textures, laisser toucher, manger en famille
1-3 ans	Alimentation proche de celle de la famille (sans sel ajouté, textures adaptées) ; autonomie à la cuillère	Repas partagés, modèles, régularité
2-6 ans	Néophobie maximale (refus des aliments nouveaux), sélectivité	Exposition répétée (8 à 15 fois), sans pression ; goûter « un peu »
6-11 ans	Ouverture progressive, influence de l'école et des pairs	Cuisiner ensemble, éducation sensorielle, cantine

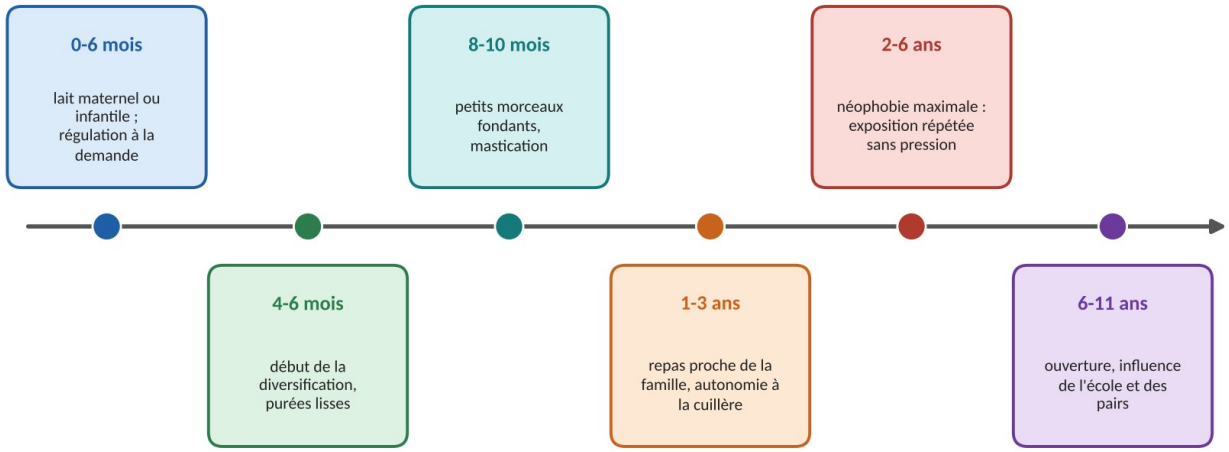


Figure 4.6 bis – Le développement du comportement alimentaire de l'enfant

Comprendre le schéma – Figure 4.6 bis

1. La frise se lit de gauche à droite ; les périodes se **chevauchent** : chaque enfant avance à son rythme.
2. **0-6 mois** : lait maternel ou infantile, à la demande ; le bébé régule seul sa prise selon sa faim.
3. **4-6 mois** : début de la diversification, avec des purées lisses et tous les groupes d'aliments, allergènes compris.
4. **8-10 mois** : petits morceaux fondants ; la mastication s'apprend en mangeant.
5. **1-3 ans** : l'enfant mange presque comme la famille (sans sel ajouté, textures adaptées) et devient autonome à la cuillère.
6. **2-6 ans** : la néophobie est maximale ; l'exposition répétée, sans pression, permet de l'atténuer (chapitre 3, section 3.4.1).
7. **6-11 ans** : ouverture progressive, sous l'influence de l'école, de la cantine et des pairs.

Pression, restriction, récompense : ce que montrent les études

Les recommandations de Satter (ci-dessous) s'appuient sur des expériences menées depuis les années 1980, surtout par l'équipe de Leann Birch, aux États-Unis.

Étude	Ce qui a été fait	Résultat
Birch et Marlin (1982)	Des enfants de 2 ans goûtent des fruits ou des fromages inconnus, de 0 à 20 fois	La préférence augmente avec le nombre d'expositions ; il en faut souvent une dizaine
Fisher et Birch (1999)	On place un aliment apprécié dans un bocal visible mais inaccessible pendant une partie de la séance	Quand le bocal est ouvert, les enfants en prennent davantage et en parlent plus : la **restriction** augmente l'attrait
Galloway et collaborateurs (2006), « Finis ta soupe »	Des enfants de 3 à 5 ans reçoivent une soupe, avec ou sans incitation à la finir	Avec la pression, ils en mangent **moins** et font davantage de remarques négatives sur la soupe
Birch et collaborateurs (1980 et 1984)	Un aliment est donné en récompense, ou l'on récompense le fait de manger un aliment	L'aliment donné en récompense devient plus apprécié ; l'aliment « récompensé » devient moins apprécié

À retenir – Trois règles tirées de ces études

- **Proposer souvent**, en petite quantité, sans obliger : l'exposition répétée fonctionne mieux que l'insistance.

- **Ne pas interdire** un aliment de façon absolue : on en fixe la fréquence et la quantité (c'est le rôle du parent, le « quoi »), sans en faire un fruit défendu.
- **Ne pas récompenser** avec la nourriture ni récompenser le fait de manger : on félicite la curiosité, pas l'assiette vide.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.14

Une maman dit : « Je cache les bonbons en haut du placard, et quand il mange ses légumes, il a droit à un bonbon. Pourtant, il ne pense qu'aux bonbons et déteste les légumes. » a) Expliquez ce comportement avec deux études du tableau. b) Proposez deux changements concrets.

Corrigé

a) La restriction (bonbons cachés) augmente leur attrait (Fisher et Birch, 1999) ; utiliser le bonbon comme récompense le valorise encore, et rend les légumes moins appréciés puisqu'ils deviennent une « épreuve » à passer (Birch et collaborateurs, 1980 et 1984 ; pression : Galloway et collaborateurs, 2006). **b)** Prévoir les bonbons à un moment fixe et en petite quantité (par exemple au goûter du mercredi), sans lien avec les légumes ; proposer les légumes sans condition, à côté d'aliments qu'il aime, et les manger devant lui avec plaisir ; le faire participer à leur préparation.

Le partage des responsabilités

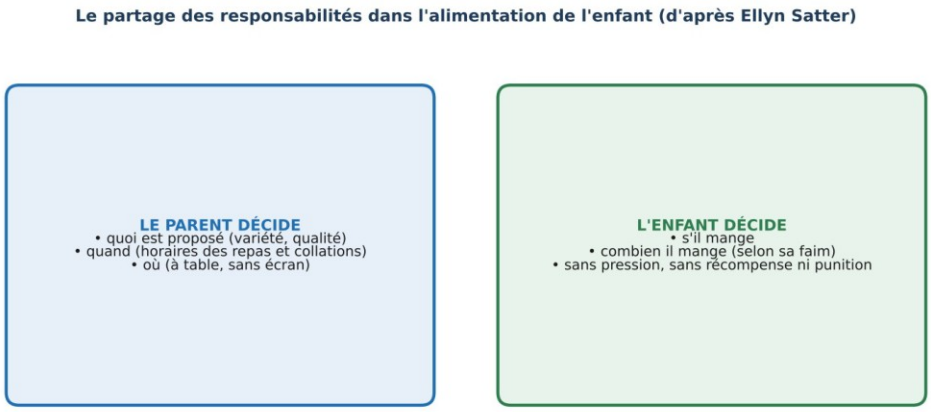


Figure 4.7 – Le partage des responsabilités (Satter)

Comprendre le schéma – Figure 4.7

1. Selon la diététicienne américaine Ellyn **Satter**, le parent est responsable du **quoi**, du **quand** et du **où** : il propose une offre variée, à des horaires réguliers, dans un cadre agréable.
2. L'enfant est responsable du **si** et du **combien** : il mange selon sa faim, sans être forcé, récompensé ni puni.
3. Ce partage protège la **régulation** naturelle de l'enfant (4.3.3) : la pression (« finis ton assiette ») et la restriction (« pas de dessert ») perturbent l'écoute des sensations et augmentent l'attrait des aliments interdits.
4. Pour le diététicien, ce modèle aide à **déculpabiliser** les parents (« ce n'est pas un échec si l'enfant ne mange pas tout ») et à recentrer leur action sur l'offre et l'ambiance.

Exemple – Calcul détaillé : programmer l'exposition répétée à un légume

Un centre de loisirs veut faire accepter le brocoli. Les études indiquent qu'il faut souvent **8 à 15 expositions**

pour qu'un enfant accepte un aliment nouveau. L'accueil a lieu 2 jours par semaine (mercredi et vendredi) ; le brocoli est proposé une fois par jour d'accueil, sous des formes variées.

- Pour 8 expositions : 8 / 2 = **4 semaines** ; pour 15 expositions : 15 / 2 = **7,5**, soit **8 semaines**.
- Sur une période de 7 semaines entre deux vacances scolaires : 7 × 2 = **14 expositions** possibles.
- **Résultat observé** (fictif) : 30 enfants ; à la 1re exposition, 6 goûtent (6 / 30 = **20 %**) ; à la 8e, 17 (17 / 30 = **56,7 %**) ; à la 14e, 22 (22 / 30 = **73,3 %**).

Leçon : la patience et la répétition sans pression sont plus efficaces que l'insistance ; il faut planifier l'exposition sur plusieurs semaines et associer les familles (même légume proposé à la maison).

Les styles parentaux en alimentation

Les psychologues distinguent quatre **styles parentaux alimentaires** selon deux dimensions : l'**exigence** (les attentes et le cadre posés par le parent) et la **sensibilité** (l'écoute de l'enfant et la chaleur de la relation) (Hughes et collaborateurs, 2005).

Style	Exigence	Sensibilité	Exemple à table	Effets observés
Démocratique (« faisant autorité »)	Élevée	Élevée	Le parent propose un repas varié, encourage à goûter, respecte la faim de l'enfant	Associé à une alimentation plus variée et à une meilleure régulation
Autoritaire	Élevée	Faible	« Tu finis ton assiette, point final. »	Pression, conflits, risque de perte de la régulation
Permissif (« indulgent »)	Faible	Élevée	L'enfant choisit ce qu'il veut, quand il veut ; plats à part	Associé à plus de produits sucrés et gras et à un risque de surpoids
Désengagé	Faible	Faible	Pas de repas organisé, l'enfant se sert seul	Le plus défavorable : irrégularité, grignotage

Le style démocratique correspond au **partage des responsabilités** : cadre clair (quoi, quand, où) et confiance dans la régulation de l'enfant (si et combien). Ces styles décrivent des tendances : un même parent peut changer de style selon la fatigue, le moment ou l'enfant. Le diététicien s'en sert pour **comprendre**, jamais pour étiqueter un parent.

La diversification alimentaire aujourd'hui

Les repères ont changé à la fin des années 2010. Le Haut Conseil de la santé publique (avis de 2020 sur les repères alimentaires des enfants de 0 à 3 ans) et Santé publique France (brochure « Pas à pas, votre enfant mange comme un grand », 2021) recommandent notamment :

- de commencer la diversification **entre 4 mois révolus et 6 mois**, pas avant 4 mois ;
- d'introduire **tous les groupes d'aliments** progressivement, y compris les **allergènes majeurs** (œuf, arachide sous forme de poudre ou de purée, gluten, poisson), sans retard, même dans les familles allergiques : retarder ne protège pas ;
- de ne pas ajouter de sel ni de sucre, et de garder le lait maternel ou un lait infantile (pas de lait de vache comme boisson principale avant 1 an) ;
- de ne pas donner de miel avant 1 an (risque de botulisme infantile) ni de fruits à coque entiers aux jeunes enfants (risque d'étouffement) ;
- d'adapter les textures à l'enfant et de proposer des petits morceaux fondants vers 8 à 10 mois, en restant à côté de lui pendant le repas.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.15

Identifiez le style parental alimentaire : a) « Je lui prépare des nuggets tous les soirs, c'est ce qu'il aime, je ne veux pas de cris. » b) « On mange à 19 h, il y a du poisson, des carottes et du pain ; il goûte, et s'il n'a plus faim, il peut sortir de table. » c) « Chez nous, chacun mange quand il rentre, il y a des plats dans le

congélateur. » d) « Pas de dessert tant que l'assiette n'est pas vide. »

Corrigé

a) Permissif (forte sensibilité, peu d'exigence). **b)** Démocratique (cadre et écoute : partage des responsabilités). **c)** Désengagé (pas de repas organisé ni d'accompagnement). **d)** Autoritaire (exigence sans écoute de la faim).

4.3.10 Les comportements alimentaires selon les âges de la vie

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · CNED : Synthèse M2 S3 §2 et §3 (p. 22 et 23) ; Synthèse M2 S3 §4 (p. 24)

Période	Comportements fréquents	Points d'attention en santé publique
Adolescence	Saut du petit-déjeuner, restauration rapide entre pairs, boissons sucrées et énergisantes, préoccupations corporelles, régimes	Apports en calcium, fer (adolescentes), vitamine D ; prévention des TCA ; littératie critique (réseaux sociaux)
Jeunes adultes	Premier logement, budget serré, repas sautés, plats préparés, livraisons	Compétences culinaires, précarité étudiante, restauration universitaire
Adultes actifs	Contraintes de temps, déjeuner pris rapidement ou au poste de travail, repas du soir copieux	Restauration d'entreprise, organisation, charge mentale du repas (souvent portée par les femmes)
Grossesse et allaitement	Envies, dégoûts, nausées, préoccupation pour la santé de l'enfant	Folates, iode, fer, prévention des toxi-infections (listériose, toxoplasmose), prise de poids adaptée
Personnes âgées	Baisse de l'appétit et de la soif, du goût et de l'odorat, troubles dentaires, isolement, repas simplifiés	Dénutrition, déshydratation, apports en protéines et en calcium, plaisir et convivialité

Attention – La charge mentale alimentaire

La planification, les courses, la cuisine et la gestion des préférences de chacun reposent encore majoritairement sur les **femmes** dans les familles françaises (enquêtes Emploi du temps de l'Insee). Un conseil nutritionnel qui ignore cette **charge mentale** risque d'ajouter une pression ; on privilégie des solutions qui **simplifient** (menus de la semaine, cuisine en avance, participation des enfants et des conjoints).

L'adolescent : autonomie, pairs et besoins de croissance

L'adolescence est une période de **croissance rapide** (pic de croissance, acquisition d'une grande partie de la masse osseuse), et aussi une période où le jeune **conquiert son autonomie** alimentaire : il mange de plus en plus hors de la famille, choisit ses achats, imite ses pairs et les modèles des réseaux sociaux (chapitre 3). Les comportements fréquents (tableau du début de la section) se comprennent à partir de ces deux réalités.

Ce que vit l'adolescent	Comportement alimentaire possible	Piste pour l'éducation
Besoin d'autonomie et refus de l'autorité	Rejet des conseils des adultes, de la cantine « des petits »	Faire choisir, faire cuisiner, faire enquêter plutôt qu'expliquer
Importance du groupe	Restauration rapide entre amis, boissons partagées	Proposer des alternatives conviviales et peu chères, ne pas disqualifier les choix du groupe
Transformation du corps, image de soi	Régimes, sauts de repas, compléments « pour la muscu »	Parler de force, d'énergie et de bien-être, jamais de poids ; repérer les signes d'alerte de TCA (4.3.13)

Ce que vit l'adolescent	Comportement alimentaire possible	Piste pour l'éducation
Décalage du sommeil	Pas de faim le matin, grignotage le soir	Aborder le sommeil et les écrans (4.3.3)
Argent de poche limité	Achats au prix, à la portion	Comparer coût et satiété (densité énergétique, 4.3.3)

Calcul détaillé – Le calcium d'une journée d'adolescent (Ciqual 2025)

Repère : la référence nutritionnelle en calcium est d'environ **1 150 mg par jour** de 11 à 17 ans (ANSES, références nutritionnelles, 2021).

Journée observée : 250 mL de lait demi-écrémé au petit-déjeuner (119 mg pour 100 g), un yaourt nature de 125 g au self (137 mg pour 100 g), 30 g d'emmental dans un sandwich (978 mg pour 100 g), 150 g de brocoli cuit (39,4 mg pour 100 g), 1,5 L d'eau du robinet (7,13 mg pour 100 g, valeur moyenne qui varie beaucoup selon les communes).

- Lait : 250 × 119 / 100 = **297,5 mg** ; yaourt : 125 × 137 / 100 = **171,3 mg** ; emmental : 30 × 978 / 100 = **293,4 mg**.
- Brocoli : 150 × 39,4 / 100 = **59,1 mg** ; eau : 1 500 × 7,13 / 100 = **107,0 mg**.
- Total : 297,5 + 171,3 + 293,4 + 59,1 + 107,0 = **928,2 mg**, soit 928,2 / 1 150 × 100 = **80,7 %** de la référence.
- Avec un second yaourt au goûter : 928,2 + 171,3 = **1 099,5 mg**, soit **95,6 %**.

Interprétation : même avec trois produits laitiers, la référence n'est pas tout à fait atteinte ; un adolescent qui saute le petit-déjeuner perd d'un coup près d'un tiers de cet apport. Le petit-déjeuner et le goûter sont donc des moments clés pour le calcium à cet âge.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.16

Une collégienne de 14 ans ne prend plus de petit-déjeuner ni de produit laitier « pour ne pas grossir » et déjeune d'une salade au self. a) Quels besoins de son âge sont menacés ? b) Quel risque de comportement faut-il envisager ? c) Que fait le diététicien qui intervient dans une action collective au collège ?

Corrigé

a) Le **calcium** (acquisition de la masse osseuse), l'**énergie** et les **protéines** nécessaires à la croissance, le **fer** (règles). **b)** Une **restriction** alimentaire motivée par le poids, qui peut être le début d'un **TCA** : il faut rester attentif aux autres signes (perte de poids, isolement, activité physique excessive, préoccupation constante). **c)** Il ne pose pas de diagnostic et ne donne pas de régime ; il signale la situation, avec discrétion, à l'infirmière scolaire ou au médecin, qui pourront orienter ; dans l'action collective, il porte des messages sur la croissance, la force et le plaisir, sans parler de poids (4.3.13).

Deux périodes de transition : la grossesse et l'entrée dans la vie étudiante

La grossesse modifie le comportement alimentaire : nausées et vomissements (surtout au premier trimestre), dégoûts (café, viande, odeurs de cuisson), envies (aliments salés, acides, sucrés), parfois **pica** (envie de substances non alimentaires comme la terre ou la glace, à signaler au médecin car elle peut accompagner une carence en fer). C'est aussi une période de grande **réceptivité** aux conseils : les futurs parents veulent « bien faire ». Les messages portent sur la sécurité alimentaire (listériose, toxoplasmose : chapitre 13 et BC1), les folates, l'iode, l'alcool zéro, et sur une prise de poids adaptée, sans régime restrictif.

L'entrée dans la vie étudiante ou professionnelle est une rupture : on quitte le cadre familial (socialisation secondaire, chapitre 3, section 3.3.2), on gère seul son budget, ses courses et ses horaires. Les comportements fréquents sont les repas sautés, les plats préparés, la restauration rapide, les livraisons, la consommation d'alcool en soirée, et parfois la **précarité alimentaire** (renoncer à des repas faute d'argent). Les leviers sont la

restauration universitaire, les épiceries solidaires étudiantes, les ateliers « cuisine petit budget » et le repérage des étudiants en difficulté par les services de santé étudiante.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.17

Pour chacune des deux périodes (grossesse, entrée dans la vie étudiante), citez deux comportements alimentaires fréquents et une action de santé publique adaptée, en indiquant le lieu où elle peut être menée.

Corrigé

Grossesse : nausées et dégoûts, envies ; inquiétude sur les aliments « autorisés ». Action : un atelier « manger pendant la grossesse » en PMI ou en maternité, lors des séances de préparation à la naissance, centré sur la sécurité alimentaire, le plaisir et les petits repas fractionnés en cas de nausées. **Entrée dans la vie étudiante** : repas sautés, restauration rapide et livraisons. Action : ateliers « cuisine petit budget » avec le service de santé étudiante et l'épicerie solidaire du campus, et promotion du restaurant universitaire.

Repérer la dénutrition de la personne âgée en santé publique

Chez la personne âgée, la baisse de l'appétit, de la soif, du goût et de l'odorat, les problèmes dentaires, l'isolement et la perte d'autonomie conduisent souvent à manger moins. Le chapitre 3 (section 3.4.9) montre comment préserver le plaisir et la convivialité ; ici, on rappelle comment **repérer** la dénutrition, pour orienter.

Définition – Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus (HAS, 2021)

Le diagnostic repose sur **au moins un critère phénotypique** et **au moins un critère étiologique**.

- **Critères phénotypiques** : perte de poids d'au moins 5 % en 1 mois ou d'au moins 10 % en 6 mois, ou d'au moins 10 % par rapport au poids habituel avant le début de la maladie ; indice de masse corporelle (IMC) inférieur à 22 kg/m² ; sarcopénie confirmée (baisse de la force et de la masse musculaires).
- **Critères étiologiques** : réduction de la prise alimentaire d'au moins 50 % pendant plus d'une semaine, ou toute réduction pendant plus de deux semaines par rapport à l'habitude ou aux besoins ; absorption réduite ; situation d'agression (maladie aiguë, inflammation chronique).

Le diagnostic est posé par un professionnel de santé ; en action collective, on repère et on oriente.

Calcul détaillé – Une situation repérée lors d'un repas partagé (données fictives)

Mme D., 81 ans, 1,58 m, pesait 63 kg il y a un mois (64 kg habituellement) et pèse aujourd'hui 59,5 kg. Sa voisine indique qu'elle « mange la moitié de son assiette depuis dix jours ».

- Perte de poids en 1 mois : 63 − 59,5 = 3,5 kg, soit 3,5 / 63 × 100 = **5,6 %** : critère phénotypique **présent** (au moins 5 % en 1 mois).
- IMC : 59,5 / (1,58 × 1,58) = 59,5 / 2,4964 = **23,8 kg/m²** : supérieur à 22, critère absent.
- Prise alimentaire réduite de moitié depuis plus d'une semaine : critère étiologique **présent**.

Conclusion : un critère phénotypique et un critère étiologique sont réunis : il faut orienter rapidement Mme D. vers son médecin traitant, qui confirmera le diagnostic et sa sévérité. L'IMC « normal » ne doit pas rassurer : c'est la **perte de poids** qui alerte.

Attention – Pas de régime après 70 ans sans avis médical

Chez la personne âgée, les régimes restrictifs (sans sel, sans graisse, sans sucre) prescrits « par habitude » diminuent le plaisir et la quantité mangée ; ils augmentent le risque de dénutrition. En santé publique, on valorise l'enrichissement des repas, le fractionnement et la convivialité.

Handicap et comportement alimentaire : deux situations fréquentes

Le diététicien en santé publique intervient aussi dans des établissements et services pour personnes en situation de handicap (foyers, instituts médico-éducatifs, ESAT). Deux situations y sont fréquentes et modifient profondément le comportement alimentaire.

Situation	Ce que l'on observe	Adaptations
Troubles de la déglutition (dysphagie) : infirmité motrice cérébrale, maladies neurologiques, grand âge	Toux pendant les repas, repas très longs, refus de certains aliments, fausses routes, perte de poids	Textures adaptées décrites par le cadre international **IDDSI** (8 niveaux, de 0 « liquide fin » à 7 « normal ») ; position assise, calme, temps suffisant ; évaluation par l'orthophoniste et le médecin
Sélectivité alimentaire dans les troubles du spectre de l'autisme	Répertoire très restreint (quelques aliments seulement), refus selon la couleur, la texture, la marque ou l'emballage, besoin de routine	Respecter les aliments acceptés, introduire très progressivement des aliments proches (même couleur ou même texture), présentation séparée des composants, repas prévisibles ; travail avec l'équipe éducative et, si besoin, l'ergothérapeute

Attention – Ne pas confondre sélectivité et caprice

Chez une personne autiste, la sélectivité tient souvent à une **sensibilité sensorielle** particulière (textures, odeurs, bruits) et au besoin de **prévisibilité** : forcer ou « affamer pour qu'il mange » aggrave l'anxiété et le refus. Une sélectivité très marquée, avec perte de poids, carences ou dépendance à des compléments, peut relever d'un **ARFID** (4.5) et justifie une évaluation médicale.

Exemple – Élargir progressivement le répertoire d'un jeune de 12 ans (IME)

Aliments acceptés : pâtes nature, pain de mie, nuggets d'une marque précise, yaourt à la vanille, compote de pommes en gourde. L'équipe choisit, avec la famille, d'avancer **par petites marches** : pâtes nature avec un peu de beurre, puis avec du fromage râpé à côté ; compote de pommes en gourde, puis compote de pommes et poires de la même marque ; nuggets maison panés comme ceux de la marque. Chaque nouvel aliment est d'abord seulement **posé** sur la table, puis touché, senti, léché, goûté, sans obligation. Après six mois, le répertoire est passé de 5 à 9 aliments : 9 − 5 = 4 aliments nouveaux, soit une augmentation de 4 / 5 × 100 = **80 %**.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.18

Dans un foyer d'accueil médicalisé, une résidente tousse souvent pendant les repas et met plus d'une heure à manger ; elle a perdu 3 kg en deux mois (poids habituel 60 kg). a) Calculez le pourcentage de perte de poids. b) Quelle hypothèse faut-il envisager ? c) Quelles sont les limites du rôle du diététicien et à qui transmettre l'information ?

Corrigé

a) 3 / 60 × 100 = **5 %** en deux mois. **b)** Des **troubles de la déglutition** (toux, repas très longs), avec un risque de fausses routes et de **dénutrition** (perte de poids importante en peu de temps). **c)** Le diététicien ne pose pas le diagnostic ; il transmet ses observations au médecin et à l'équipe soignante, qui demanderont une évaluation (orthophoniste) ; la texture adaptée (niveau IDDSI) sera ensuite définie avec eux, et le diététicien veillera à l'apport en énergie et en protéines et au plaisir de manger.

La personne âgée : changements physiques, sociaux et psychiques

On parle souvent de « personne âgée » à partir de **60 ou 65 ans** selon les sources (OMS, Insee) ; la HAS retient **70 ans et plus** pour le diagnostic de la dénutrition (2021). L'âge de la retraite n'est pas un critère de santé : il a changé plusieurs fois depuis 2010.

Plan	Changements	Conséquences sur l'alimentation
Physique	Baisse de la vue (presbytie), de l'audition, du goût et de l'odorat ; mauvais état dentaire ; perte de muscle (sarcopénie), risque de chute ; digestion plus lente ; moindre sensation de soif	Repas moins attrayants, mastication difficile, déshydratation ; risque de **dénutrition**
Social	Retraite (revenus, activité), veuvage, éloignement des enfants, entrée en établissement (menus imposés, horaires collectifs)	Solitude, repas sautés ou simplifiés, perte de choix
Psychique	Difficulté à accepter le corps qui change, sentiment d'inutilité, dépression	Perte d'appétit ; dans les cas graves, **syndrome de glissement** : la personne refuse de s'alimenter et de se soigner, ce qui met sa vie en danger en quelques semaines ; c'est une urgence médicale

Lien diététique – Garder le plaisir et le choix

Les repas mixés doivent rester présentés de façon appétissante (formes, couleurs) ; on propose le choix entre deux plats, des collations enrichies, et on fait du repas un moment de lien.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.3.9 et 4.3.10 – L'enfant et les âges de la vie

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Entre quels âges commence la diversification alimentaire ?
2. Que décide le parent et que décide l'enfant, selon Satter ?
3. Qu'ont montré Galloway et collaborateurs (2006) ?
4. Citez les quatre styles parentaux alimentaires.
5. Pourquoi ne pas donner de miel avant 1 an ?
6. Citez deux critères qui, réunis, permettent de diagnostiquer une dénutrition chez une personne de 70 ans et plus (HAS, 2021).

Corrigé – Point d'étape 4.3.9 et 4.3.10

1. Entre 4 mois révolus et 6 mois.
2. Le parent décide quoi, quand et où ; l'enfant décide s'il mange et combien.
3. La pression pour finir une soupe fait manger moins et augmente les remarques négatives sur l'aliment.
4. Démocratique, autoritaire, permissif, désengagé.
5. Risque de botulisme infantile.
6. Au moins un critère phénotypique (par exemple une perte de poids d'au moins 5 % en un mois) et au moins un critère étiologique (par exemple une prise alimentaire réduite de moitié pendant plus d'une semaine).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.

Mon score	Ce que je fais
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

4.3.11 Observer et mesurer les comportements alimentaires

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · CNED : Synthèse M2 S3 §4 (p. 24)

Outil	Principe	Usage et limites
Rappel des 24 heures	Entretien sur tout ce qui a été consommé la veille	Précis mais une seule journée (variabilité) ; BC1, enquêtes nationales
Carnet ou journal alimentaire	Notation de tout ce qui est consommé pendant 3 à 7 jours	Modifie le comportement (on mange différemment quand on note) ; contraignant
Questionnaire de fréquence	Fréquence habituelle de consommation de groupes d'aliments	Rapide, adapté aux projets collectifs ; imprécis sur les quantités
Questionnaires de comportement	Restriction, désinhibition, émotions (TFEQ, DEBQ)	Outils de recherche ou de soin ; à manier avec prudence en collectif
Observation directe	Grille d'observation d'un repas ou d'un goûter	Comportements réels ; effet de la présence de l'observateur
Pesée des restes	Différence entre servi et consommé, en restauration collective	Objectif ; ne dit pas qui mange quoi

Exemple – Calcul détaillé : conformité aux repères à partir d'un questionnaire de fréquence

Un questionnaire auprès de 40 adultes d'une épicerie solidaire demande, pour la semaine précédente, le nombre de jours où ils ont mangé des légumes, et le nombre de fois où ils ont mangé des légumes secs.

- Légumes **tous les jours** (7 jours sur 7) : 14 personnes, soit 14 / 40 × 100 = **35 %**.
- Légumes secs **au moins 2 fois** dans la semaine : 11 personnes, soit 11 / 40 × 100 = **27,5 %**.
- Nombre moyen de prises de légumes secs : réponses 0 (×18), 1 (×11), 2 (×7), 3 (×3), 4 (×1). Total des prises : 0 × 18 + 1 × 11 + 2 × 7 + 3 × 3 + 4 × 1 = 0 + 11 + 14 + 9 + 4 = **38** ; moyenne : 38 / 40 = **0,95 fois par semaine** (le repère est d'au moins 2 fois).
- Vérification des effectifs : 18 + 11 + 7 + 3 + 1 = **40** ; au moins 2 fois : 7 + 3 + 1 = **11** . ✓ ✓

Interprétation : la consommation de légumes secs est très en dessous du repère, ce qui justifie un objectif spécifique ; la question porte sur une semaine (biais de mémoire limité) mais reste déclarative.

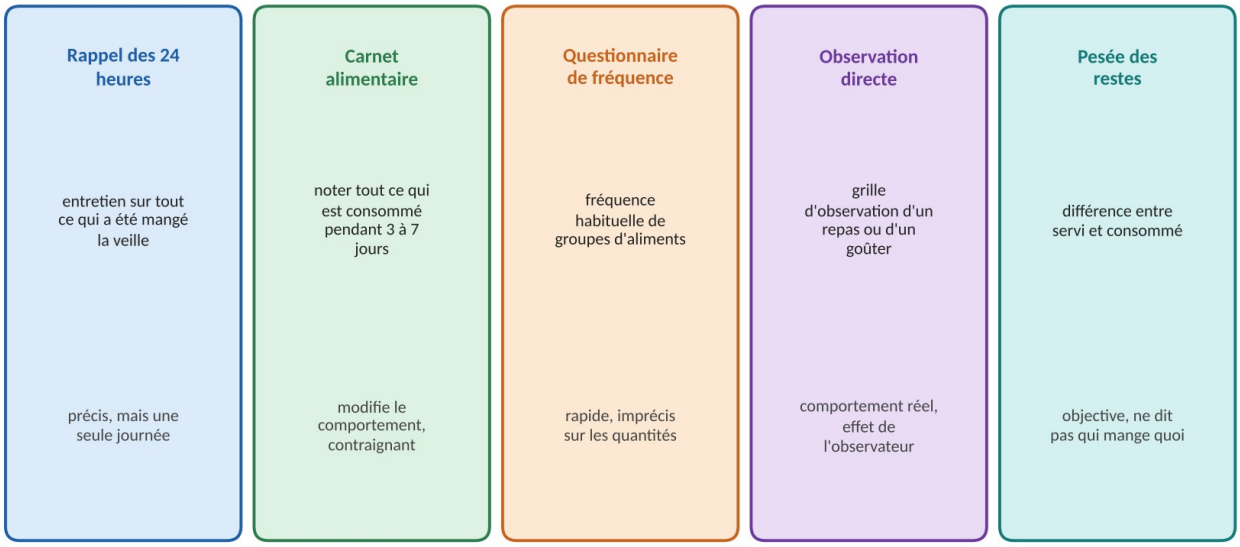


Figure 4.7 bis – Cinq outils pour observer et mesurer les comportements alimentaires

Comprendre le schéma – Figure 4.7 bis

1. Chaque colonne présente un outil : son **nom**, son **principe** (au milieu) et sa principale **limite** (en bas).
2. Les trois premiers outils (rappel des 24 heures, carnet, questionnaire de fréquence) sont **déclaratifs** : ils reposent sur ce que la personne dit, avec des biais de mémoire et de désirabilité sociale.
3. Les deux derniers (observation directe, pesée des restes) mesurent ce qui se passe **réellement**, mais ne disent pas pourquoi ni, pour la pesée, qui mange quoi.
4. On combine souvent un outil déclaratif et un outil d'observation pour croiser les résultats.

Construire une grille d'observation d'un repas

L'observation directe est l'outil le plus utile pour comprendre le **contexte** d'un repas (ambiance, durée, rôle des adultes), que les questionnaires saisissent mal. Une grille rend l'observation **systématique** et comparable d'un repas à l'autre ou d'un observateur à l'autre.

Méthode pas à pas – Construire et utiliser une grille d'observation

1. Définir la question : par exemple, « comment les adultes accompagnent-ils le goûter au centre de loisirs ? ».

2. Choisir des éléments observables, décrits sans interprétation : « l'adulte est assis à la table des enfants » plutôt que « l'adulte est disponible ».

3. Prévoir une modalité de réponse simple : oui ou non, nombre, durée en minutes.

4. Tester la grille sur un ou deux repas, à deux observateurs, et comparer : si les observateurs ne notent pas la même chose, reformuler les éléments.

5. Observer plusieurs repas (jours différents) pour limiter l'effet d'un jour particulier ; se faire discret pour limiter l'effet de l'observateur.

6. Traiter : pourcentage de repas où chaque élément est présent ; comparer avant et après une action.

Élément observé (exemple : goûter en centre de loisirs)	Réponse
Les enfants sont assis	Oui / Non
Un adulte est assis avec les enfants et goûte avec eux	Oui / Non
Durée du goûter	… minutes

Élément observé (exemple : goûter en centre de loisirs)	Réponse
L'eau est proposée	Oui / Non
Un aliment est imposé (« tu finis ») ou utilisé comme récompense	Oui / Non
Les enfants participent (servir, distribuer, ranger)	Oui / Non

Calcul détaillé – Accord entre deux observateurs (données fictives)

Deux stagiaires observent les mêmes 10 goûters avec la grille. Pour l'élément « un adulte est assis avec les enfants », ils notent la même réponse pour 8 goûters sur 10.

- Taux d'accord : 8 / 10 × 100 = **80 %**.
- Pour l'élément « un aliment est imposé ou utilisé comme récompense », ils ne sont d'accord que pour 6 goûters sur 10 : **60 %**. Cet élément regroupe deux comportements différents : on le sépare en deux éléments (« un aliment est imposé » ; « un aliment sert de récompense ») et l'on refait le test.

Lecture : un élément mal défini produit des résultats peu fiables ; tester la grille avant l'enquête évite de mesurer des impressions.

Les biais des enquêtes alimentaires

Biais	Explication	Comment le limiter
Sous-déclaration	On oublie ou on minimise ce que l'on a mangé (grignotage, boissons, sauces), surtout pour les aliments jugés « mauvais »	Relances (« et à boire ? »), photos de portions, rappel en plusieurs passages
Désirabilité sociale	On déclare ce qui paraît « bien » (plus de légumes, moins de sodas)	Questionnaire anonyme, questions neutres, enquêteur extérieur au groupe
Mémoire	Les souvenirs s'effacent vite, surtout pour les quantités	Période courte (la veille, la semaine précédente)
Modification du comportement	Le fait de noter ou d'être observé change ce que l'on mange	Plusieurs jours, discrétion de l'observateur, comparaison avec les jours non observés

Le rappel des 24 heures en pratique : la méthode des passages successifs

Le rappel des 24 heures est l'outil déclaratif le plus utilisé en entretien. Pour limiter les oublis, les grandes enquêtes (par exemple le Département de l'agriculture des États-Unis, avec sa méthode dite *Automated Multiple-Pass Method*) le conduisent en **plusieurs passages** sur la même journée.

Méthode pas à pas – Les cinq passages d'un rappel des 24 heures

1. Liste rapide : la personne cite librement tout ce qu'elle a mangé et bu la veille, de son lever à son coucher, sans être interrompue.

2. Aliments souvent oubliés : on relance par catégorie : boissons (dont alcool), sucreries, biscuits, fruits, pain, fromage, sauces, ce qui a été goûté en cuisinant.

3. Heure et occasion : pour chaque prise, on précise l'heure, le lieu et la compagnie (seul, en famille, devant un écran) ; cette étape fait souvent revenir des prises oubliées.

4. Détails : on précise chaque aliment (préparation, marque, matière grasse ajoutée) et la **quantité**, à l'aide de mesures ménagères, de photos de portions ou de vaisselle réelle.

5. Vérification finale : on relit la journée avec la personne, en lui demandant si quelque chose manque, par exemple entre deux prises éloignées.

Calcul détaillé – Ce que les relances font apparaître (données fictives)

Au premier passage, une personne déclare une journée de **1 450 kcal**. Les relances font apparaître : 2 cuillères à soupe d'huile dans la poêlée du soir (environ 10 g chacune ; Ciqual 2025 : 900 kcal pour 100 g), un verre de 200 mL de cola sucré (10 g de sucres pour 100 g, 40,1 kcal pour 100 g, soit environ **80 kcal**), et un biscuit au chocolat d'environ **150 kcal** mangé en préparant le repas.

- Huile : 2 × 10 × 900 / 100 = **180 kcal**.
- Sucres du cola : 200 × 10 / 100 = **20 g**, soit environ quatre morceaux de sucre.
- Total corrigé : 1 450 + 180 + 80 + 150 = **1 860 kcal**, soit 410 kcal de plus, une hausse de 410 / 1 450 × 100 = **28,3 %**.
- Contrôle de plausibilité : le métabolisme de base de cette personne est estimé à 1 380 kcal (donnée fournie). Au premier passage, le rapport apport déclaré / métabolisme de base valait 1 450 / 1 380 = **1,05** ; après relances, 1 860 / 1 380 = **1,35**.

Interprétation : un rapport inférieur à environ 1,2 fait suspecter une sous-déclaration chez une personne qui garde un poids stable (seuils proposés par Goldberg et collaborateurs, 1991, qui varient selon le nombre de jours recueillis). Les relances ne sont donc pas un détail : sans elles, on aurait conclu à tort à une alimentation insuffisante.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.19

Lors d'un rappel des 24 heures, une adolescente cite seulement : « Rien le matin, un sandwich au self, des pâtes le soir. » a) Quelles relances faites-vous au deuxième passage ? b) Quelle question de l'étape 3 peut faire apparaître des prises oubliées ? c) Pourquoi faut-il rester neutre pendant tout le recueil ?

Corrigé

a) « Qu'avez-vous bu dans la journée, à la maison et dehors ? » ; « Avez-vous mangé quelque chose en sortant du collège, ou avec vos amis ? » ; « Y avait-il quelque chose avec les pâtes : sauce, fromage, beurre ? » ; « Avez-vous mangé un fruit, un yaourt, des biscuits ? ». **b)** « Que faisiez-vous entre la fin des cours et le dîner ? » : cette question sur le moment et le lieu fait souvent revenir un goûter ou un grignotage. **c)** Pour limiter la **désirabilité sociale** : une réaction (étonnement, conseil) pendant le recueil pousse la personne à cacher ou à embellir ce qu'elle mange ; les conseils viennent après, une fois le recueil terminé.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.3.11 – Observer et mesurer

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez cinq outils d'observation ou de mesure des comportements alimentaires.
2. Quelle est la principale limite du rappel des 24 heures ?
3. Pourquoi le carnet alimentaire modifie-t-il le comportement ?
4. Qu'apporte l'observation directe que les questionnaires n'apportent pas ?
5. Comment vérifier qu'une grille d'observation est fiable ?
6. Citez deux biais des enquêtes alimentaires déclaratives.

Corrigé – Point d'étape 4.3.11

1. Rappel des 24 heures, carnet alimentaire, questionnaire de fréquence, observation directe, pesée des restes (et questionnaires de comportement).
2. Il ne porte que sur une journée, qui peut ne pas être représentative.
3. Le fait de noter rend attentif à ce que l'on mange ; on mange souvent « mieux » ou moins les jours où l'on note.

4. Le contexte réel du repas : ambiance, durée, interactions, rôle des adultes.

5. En la testant à deux observateurs sur les mêmes repas et en calculant le taux d'accord ; on reformule les éléments sur lesquels ils ne sont pas d'accord.

6. Sous-déclaration, désirabilité sociale, biais de mémoire.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

4.3.12 Vers une alimentation durable : santé et environnement

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Définition – Alimentation durable (FAO, 2010)

Alimentation qui protège la biodiversité et les écosystèmes, est **acceptable culturellement**, **accessible**, **économiquement équitable et abordable**, **nutritionnellement sûre et saine**, et optimise l'usage des ressources naturelles et humaines. Elle concerne toute la chaîne : production, transformation, distribution, consommation, gaspillage.

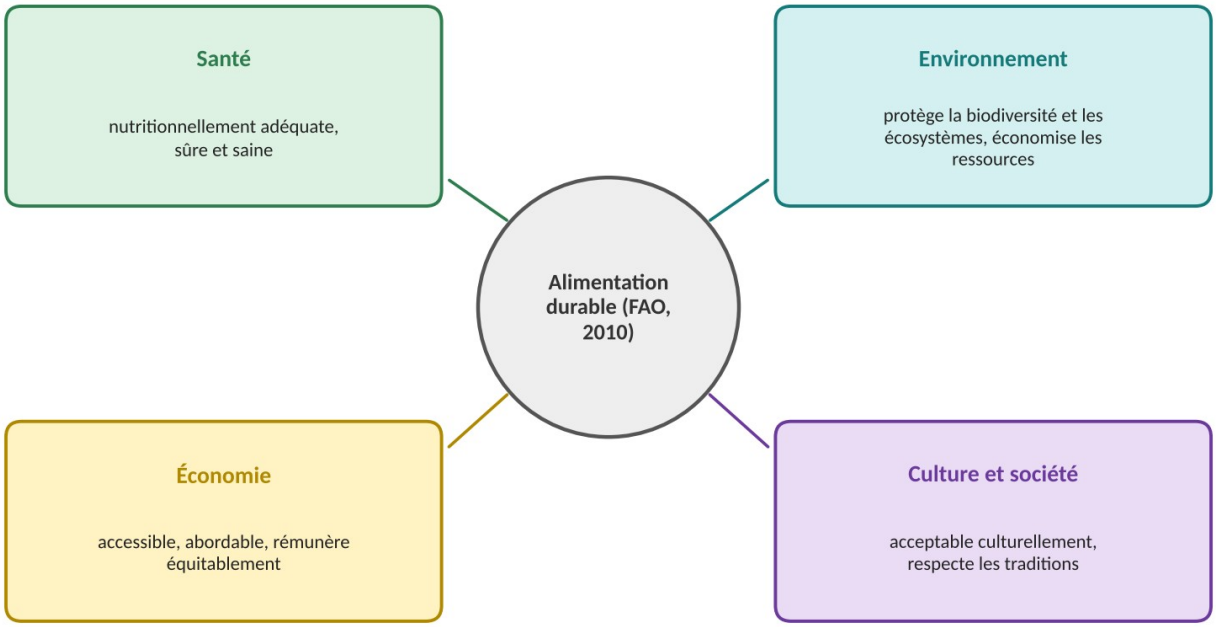


Figure 4.7 ter – Les quatre dimensions de l'alimentation durable (d'après la FAO, 2010)

Comprendre le schéma – Figure 4.7 ter

1. Au centre, l'**alimentation durable** telle que la définit la FAO (2010).

2. Santé : une alimentation nutritionnellement adéquate, sûre (sécurité sanitaire) et saine.

3. Environnement : elle protège la biodiversité et les écosystèmes et économise les ressources (eau, sols, énergie).

4. Économie : elle est accessible et abordable pour les consommateurs, et rémunère équitablement les

producteurs.

5. **Culture et société** : elle est acceptable culturellement et respecte les traditions.
6. Une action « durable » doit tenir les quatre dimensions ensemble : un panier bio trop cher pour les familles d'un quartier ne respecte pas la dimension économique ; un menu végétarien que personne ne mange ne respecte pas la dimension culturelle.

Le régime de santé planétaire

En 2019, la commission **EAT-Lancet** a proposé un « régime de santé planétaire » compatible avec la santé humaine et les limites de la planète pour 10 milliards d'habitants en 2050. Pour environ 2 500 kcal par jour, il comprend notamment : céréales complètes environ 230 g, légumes 300 g, fruits 200 g, produits laitiers 250 g, légumineuses environ 75 g (dont soja), fruits à coque 50 g, poisson environ 28 g, volaille environ 29 g, œufs 13 g, et seulement environ **14 g de viande rouge** par jour (soit environ 100 g par semaine). La mise à jour de la commission EAT-Lancet (*The Lancet*, octobre 2025) garde ces ordres de grandeur : au plus 98 g de viande rouge par semaine (14 g par jour), 203 g de volaille et 196 g de poisson par semaine, et au moins 125 g de légumineuses et fruits à coque par jour. En France, les repères de 2019 (limiter la viande à 500 g par semaine, privilégier la volaille, au moins 2 fois des légumes secs par semaine) et l'avis du HCSP de 2025 vont dans le même sens.

L'empreinte carbone de l'assiette

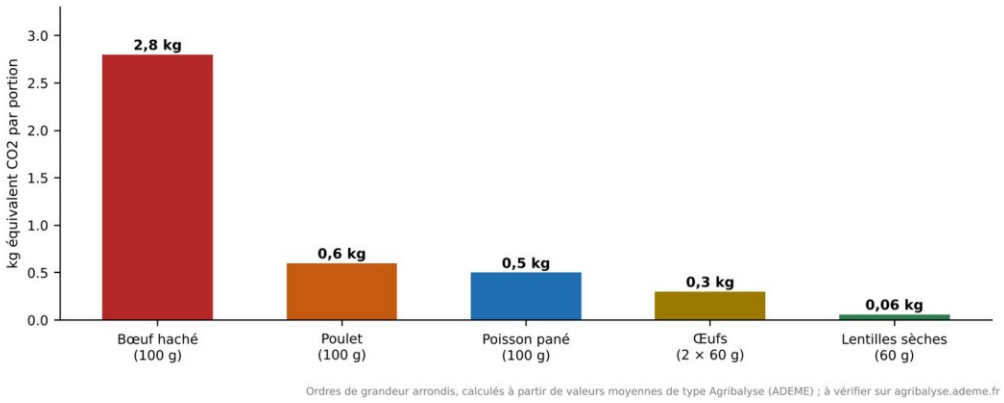


Figure 4.8 – Empreinte carbone de quelques sources de protéines (par portion)

Comprendre le schéma – Figure 4.8

1. Les valeurs sont des **ordres de grandeur** (base de données Agribalyse de l'ADEME, valeurs moyennes arrondies) ; elles varient selon le mode de production.
2. Une portion de **bœuf** émet environ **2,8 kg** équivalent CO2, soit près de **50 fois** plus qu'une portion de **lentilles** (0,06 kg) : 2,8 / 0,06 = 46,7.
3. La **volaille** (0,6 kg) et les **œufs** (0,3 kg) se situent à un niveau intermédiaire.
4. Remplacer une partie de la viande rouge par des légumineuses est donc à la fois **favorable à la santé**, **économique** (chapitre 2 : 0,16 € la portion de lentilles) et **favorable au climat** : c'est l'un des messages centraux de la SNANC 2025-2030.

Exemple – Calcul détaillé : l'empreinte d'une semaine de déjeuners

Une famille de 4 personnes mange au déjeuner, chaque semaine : bœuf haché 3 fois, poulet 2 fois, œufs 1 fois, lentilles 1 fois (portions de la figure 4.8).

- Par personne et par semaine : 3 × 2,8 + 2 × 0,6 + 1 × 0,3 + 1 × 0,06 = 8,4 + 1,2 + 0,3 + 0,06 = **9,96 kg** CO2e.
- Pour la famille : 9,96 × 4 = **39,84 kg** CO2e par semaine.
- **Scénario modifié** : bœuf 1 fois, poulet 2 fois, œufs 1 fois, lentilles ou pois chiches 3 fois : 2,8 + 1,2 + 0,3 + 3

× 0,06 = 2,8 + 1,2 + 0,3 + 0,18 = **4,48 kg** par personne ; famille : 4,48 × 4 = **17,92 kg**.

- **Réduction** : 39,84 − 17,92 = **21,92 kg** par semaine, soit 21,92 / 39,84 × 100 = **55 %** ; sur 52 semaines : 21,92 × 52 = **1 139,8 kg**, soit plus d'une tonne d'équivalent CO2 par an.
- **Effet sur le budget** (prix fictifs : bœuf 0,89 €, poulet 0,75 €, œufs 0,56 €, lentilles 0,16 € par portion) : avant : 3 × 0,89 + 2 × 0,75 + 0,56 + 0,16 = 2,67 + 1,50 + 0,56 + 0,16 = **4,89 €** par personne et par semaine ; après : 0,89 + 1,50 + 0,56 + 3 × 0,16 = 0,89 + 1,50 + 0,56 + 0,48 = **3,43 €** ; économie : 4,89 − 3,43 = **1,46 €** par personne et par semaine, soit 1,46 × 4 × 52 = **303,68 €** par an pour la famille.

Message pour un atelier : « Deux plats de légumes secs en plus par semaine : bon pour la santé, pour le porte- monnaie et pour la planète. »

Attention – Durable, mais accessible et sans culpabiliser

Les messages environnementaux ne doivent pas culpabiliser les familles modestes, dont l'empreinte globale est souvent plus faible, ni rendre l'alimentation durable synonyme de produits chers (bio, labels) : on valorise d'abord ce qui est **à la fois sain, durable et économique** (légumes secs, produits de saison, eau du robinet, anti-gaspillage).

Saison, local, labels : ce que fixe la loi EGalim

La loi EGalim (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018) a fixé des objectifs à la **restauration collective**. Depuis le 1er janvier 2022, les restaurants collectifs publics doivent servir au moins **50 % de produits durables et de qualité** (en valeur d'achat), dont au moins **20 % de produits issus de l'agriculture biologique**. Les produits « durables et de qualité » comprennent notamment les produits sous signe officiel de qualité (Label rouge, appellation d'origine, indication géographique), les produits de la mention « haute valeur environnementale » selon les conditions fixées par les textes, et les produits biologiques. La loi a aussi rendu obligatoire, en restauration scolaire, un **menu végétarien au moins une fois par semaine** (expérimentation en 2019, pérennisée par la loi Climat et résilience du 22 août 2021), et un **diagnostic du gaspillage alimentaire**.

Calcul détaillé – Le collège respecte-t-il les objectifs EGalim ? (données fictives)

Achats alimentaires de l'année : **180 000 €**, dont **72 000 €** de produits durables et de qualité, parmi lesquels **27 000 €** de produits biologiques.

- Part des produits durables et de qualité : 72 000 / 180 000 × 100 = **40,0 %** (objectif : 50 %).
- Part des produits biologiques : 27 000 / 180 000 × 100 = **15,0 %** (objectif : 20 %).
- Montants à atteindre : 50 % de 180 000 = **90 000 €** de produits durables, soit 90 000 − 72 000 = **18 000 €** de plus ; 20 % de 180 000 = **36 000 €** de produits bio, soit 36 000 − 27 000 = **9 000 €** de plus.

Piste : remplacer une partie de la viande par des légumineuses biologiques (bon marché) libère du budget pour acheter de la viande sous label ; la réduction du gaspillage libère aussi des marges.

Saison	Exemples de légumes	Exemples de fruits
Hiver	Chou, poireau, carotte, céleri, navet, endive, courge	Pomme, poire, agrumes (importés)
Printemps	Asperge, radis, petits pois, épinard, salade	Fraise (fin du printemps), rhubarbe
Été	Tomate, courgette, aubergine, poivron, haricot vert	Abricot, pêche, melon, cerise, prune
Automne	Courge, potiron, champignon, chou-fleur, betterave	Raisin, pomme, poire, figue

À vous de jouer – Exercice d'application 4.20

Un centre social veut organiser des « ateliers durables ». L'animatrice propose un atelier en janvier autour d'une salade de tomates, de courgettes et de fraises bio. a) Quelles dimensions de l'alimentation durable ne sont pas respectées ? b) Proposez une recette de saison, peu coûteuse et appréciée. c) Indiquez un message

qui ne culpabilise pas les familles.

Corrigé

a) Dimension **environnementale** : tomates, courgettes et fraises ne sont pas de saison en janvier (culture sous serre chauffée ou importation lointaine). Dimension **économique** : ces produits bio hors saison sont chers, peu accessibles aux familles. **b)** Une soupe de potiron et de carottes avec des lentilles corail, servie avec du pain et du fromage, puis une compote de pommes maison : de saison, peu chère, rassasiante. **c)** « Manger de saison, c'est meilleur et moins cher : les légumes d'hiver, en soupe ou en gratin, font des repas bons pour la santé, le porte-monnaie et la planète. »

Faire accepter les plats végétariens en restauration collective

Rendre obligatoire un menu végétarien hebdomadaire (voir ci-dessus) ne suffit pas : un plat que les convives ne prennent pas, ou laissent dans l'assiette, n'apporte rien à leur santé et augmente le gaspillage. L'acceptation dépend des **comportements** étudiés dans ce chapitre : habitudes, normes sociales, présentation, goût.

Levier	Ce que l'on sait	Application en restauration collective
Disponibilité	Dans des cafétérias universitaires de Cambridge, passer d'une option végétarienne sur quatre à deux sur quatre a augmenté les ventes de plats végétariens d'environ 40 à 80 % selon les sites, sans baisse de fréquentation (Garnett et collaborateurs, 2019)	Proposer régulièrement une option végétarienne, pas seulement le jour obligatoire
Nom et présentation	Regrouper les plats dans une rubrique « végétarienne » à part les fait moins choisir par les mangeurs de viande (Bacon et Krpan, 2018)	Nommer le plat par ce qu'il apporte en goût (« dahl de lentilles au lait de coco ») plutôt que par l'absence de viande (« plat sans viande ») ; l'intégrer à la carte normale
Familiarité	Un plat inconnu est d'abord refusé (néophobie, chapitre 3)	Commencer par des plats connus (lasagnes de légumes, chili sin carne, omelette, couscous de légumes et pois chiches) avant des recettes nouvelles
Goût et savoir-faire	Un plat végétarien fade ou sec est vite rejeté	Former les cuisiniers (épices, sauces, cuisson des légumineuses), faire goûter l'équipe avant la mise au menu
Normes sociales	On choisit ce que choisissent les autres	Faire goûter des portions de dégustation, associer les élèves (commission menus), afficher les plats préférés

Calcul détaillé – Un dahl de lentilles corail au riz pour un collégien (Ciqual 2025, une portion)

Ingrédients (poids crus) : lentilles corail sèches 50 g, riz blanc 60 g, tomates pelées égouttées 80 g, oignon 20 g, lait de coco 20 g, huile de colza 5 g.

- **Énergie** : 164,0 + 210,0 + 13,1 + 7,8 + 39,8 + 45,0 = **480 kcal**.
- **Protéines** : 13,85 + 4,21 + 0,72 + 0,22 + 0,39 + 0 = **19,4 g**, dont 13,85 / 19,39 × 100 = **71 %** apportés par les lentilles.
- **Fibres** : **10,1 g** ; **fer** : **5,4 mg** (fer non héminique, mieux absorbé avec un fruit riche en vitamine C au dessert).
- Comparaison avec un steak haché à 15 % de matières grasses (100 g cru) et 60 g de riz : 425 kcal, 24,4 g de protéines, 0,9 g de fibres, 3,8 mg de fer, 15,3 g de lipides (contre 10,1 g pour le dahl).

Interprétation : le dahl apporte un peu moins de protéines (19,4 g contre 24,4 g), mais une quantité

suffisante pour un plat principal, associée aux céréales (riz) pour la complémentarité (4.3.6) ; il apporte onze fois plus de fibres et moins de lipides. Un produit laitier au menu complète l'apport en protéines et en calcium.

Attention – Mesurer l'acceptation avant de conclure

Pour savoir si un plat végétarien « marche », on ne se fie pas aux impressions : on compte les plats pris (choix), on pèse les **restes** (4.3.11) et on recueille l'avis des convives (échelle hédonique, 4.3.16). Un plat moins pris la première semaine peut progresser avec l'habitude : on refait la mesure après trois ou quatre passages.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.21

Dans un lycée, le jour du menu végétarien, 180 élèves sur 520 inscrits (34,6 %) ne viennent pas à la cantine, contre 60 les autres jours. Le plat proposé est « Plat sans viande : galette de légumes ». a) Calculez le taux d'absence habituel et l'écart. b) Proposez trois leviers d'action. c) Indiquez deux indicateurs pour évaluer l'effet de vos actions.

Corrigé

a) Taux habituel : 60 / 520 × 100 = **11,5 %** ; le jour végétarien : 180 / 520 × 100 = **34,6 %** ; écart : 34,6 − 11,5 = **23,1 points**, soit 120 élèves de plus qui ne viennent pas. **b)** Renommer et rendre le plat appétissant (« galette croustillante de pois chiches, sauce yaourt au cumin ») ; proposer des plats familiers (chili sin carne, lasagnes de légumes) ; associer les élèves à une commission menus et organiser une dégustation ; former l'équipe de cuisine. **c)** Taux de fréquentation le jour végétarien ; poids des restes du plat principal par élève ; note moyenne à une échelle hédonique.

4.3.13 Les troubles du comportement alimentaire : comprendre pour prévenir et orienter

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Des troubles fréquents et graves

Les troubles du comportement alimentaire (TCA) sont des troubles psychiatriques (4.3.3) qui débutent le plus souvent à l'**adolescence** ou chez le **jeune adulte**, touchent davantage les femmes mais aussi les hommes, et ont des conséquences somatiques, psychiques et sociales importantes ; l'anorexie mentale a l'un des taux de mortalité les plus élevés des troubles psychiatriques.

Trouble	Prévalence vie entière (ordres de grandeur)	Source
Anorexie mentale	Environ 0,9 % des femmes et 0,3 % des hommes	Hudson et coll., 2007 (États-Unis) ; HAS, 2010
Boulimie	Environ 1,5 % des femmes et 0,5 % des hommes	Hudson et coll., 2007 ; HAS, 2019
Hyperphagie boulimique	Environ 3,5 % des femmes et 2 % des hommes	Hudson et coll., 2007 ; HAS, 2019

Attention – Prudence avec les chiffres

Les prévalences varient selon les pays, les définitions (DSM-IV ou DSM-5) et les méthodes ; les formes « non

spécifiées » sont plus fréquentes que les formes typiques, et de nombreuses personnes ne sont jamais diagnostiquées. Retenez l'ordre de grandeur : **plusieurs pour cent** de la population sont concernés au cours de la vie, dont une majorité de jeunes.

Facteurs de risque et facteurs de protection

Facteurs de risque	Facteurs de protection
Régimes restrictifs et restriction cognitive (chapitre 4)	Repas familiaux réguliers et conviviaux
Insatisfaction corporelle, idéal de minceur intériorisé	Estime de soi, image corporelle positive
Moqueries sur le poids, stigmatisation	Environnement non stigmatisant
Pratique de sports à catégorie de poids ou esthétiques	Compétences psychosociales (gestion des émotions, pensée critique)
Exposition intensive aux contenus « minceur » des réseaux sociaux	Littératie médiatique, esprit critique
Perfectionnisme, anxiété, événements de vie difficiles	Soutien social, écoute, accès aux soins

Le rôle du diététicien en santé publique

- **Prévention universelle** : messages centrés sur la santé, le plaisir et les sensations plutôt que sur le poids ; pas de régimes, pas d'aliments « interdits » ; promotion d'une image corporelle positive ; littératie critique des réseaux (chapitre 5).
- **Prévention ciblée** : actions dans les clubs sportifs, les écoles de danse, les lycées, auprès des entraîneurs et des enseignants (repérage des signes d'alerte).
- **Repérage et orientation** : face à des signes d'alerte (perte de poids rapide, restriction sévère, vomissements, crises), en parler en privé, avec bienveillance, et orienter vers le médecin traitant, l'infirmière scolaire ou une structure spécialisée (annuaire de la Fédération française anorexie boulimie, FFAB) ; les professionnels de santé disposent d'outils de repérage comme le questionnaire **SCOFF** (5 questions), qui ne sert pas au diagnostic et n'est pas destiné à être utilisé en atelier collectif.
- **Éviter les effets indésirables** : une action « contre l'obésité » mal conçue peut favoriser des TCA (pesées publiques, objectifs de perte de poids chez les adolescents).

Exemple – Une action de prévention dans un club de gymnastique

Le diététicien intervient auprès des entraîneurs (formation : besoins des jeunes sportives, signes d'alerte, conduite à tenir, vocabulaire à éviter sur le poids et la silhouette), puis auprès des gymnastes de 12 à 16 ans (atelier « manger pour performer et grandir » : collations, hydratation, plaisir), et auprès des parents (réunion). Il n'organise aucune pesée et oriente individuellement, en lien avec le médecin du club, les jeunes chez qui des signes d'alerte sont repérés.

Signes d'alerte et conduite à tenir

Le diététicien qui intervient en milieu scolaire, sportif ou associatif peut être le premier adulte à remarquer des signes d'alerte. Il ne pose pas de diagnostic, mais il sait **quoi observer** et **comment réagir**.

Type de signe	Exemples
Physiques	Perte de poids rapide ou cassure de la courbe de croissance chez l'enfant ; fatigue, malaises, sensation de froid ; arrêt des règles ; variations de poids importantes
Alimentaires	Restriction sévère, évitement de familles entières d'aliments, repas sautés de façon répétée ; crises de « boulimie » (grandes quantités, perte de contrôle) ; vomissements, prise de laxatifs

Type de signe	Exemples
Comportementaux	Activité physique excessive et compulsive ; isolement au moment des repas ; rituels (couper les aliments en petits morceaux, compter) ; pesées fréquentes
Psychologiques	Peur intense de grossir ; préoccupation constante pour le poids, la silhouette, les calories ; perception déformée du corps ; anxiété, tristesse

Méthode pas à pas – Réagir face à des signes d'alerte chez un jeune

1. Ne pas en parler devant le groupe ; choisir un moment calme et individuel.

2. Exprimer son inquiétude en décrivant des faits, sans juger ni parler de poids : « J'ai remarqué que tu ne déjeunais plus avec les autres, je m'inquiète pour toi. »

3. Écouter sans chercher à convaincre ; ne pas donner de conseils diététiques pour « corriger ».

4. Orienter : infirmière ou médecin scolaire, médecin traitant, structures spécialisées (annuaire de la Fédération française anorexie boulimie, FFAB) ; informer les parents pour un mineur, avec l'infirmière.

5. Transmettre l'information seulement aux professionnels concernés, dans le respect du secret partagé (chapitre 6, section 6.3.4).

À noter – Orthorexie et « bigorexie » : des mots à manier avec prudence

- L'**orthorexie** désigne une préoccupation excessive pour une alimentation « saine » ou « pure », avec des règles de plus en plus strictes, de l'anxiété et un retentissement social. Le terme a été proposé par le médecin américain Steven Bratman (1997) ; ce n'est **pas** un diagnostic du DSM-5.
- La **dysmorphie musculaire** (parfois appelée « bigorexie ») est une préoccupation excessive pour un corps jugé pas assez musclé, avec entraînement compulsif, régimes hyperprotéinés et parfois produits dopants ; elle concerne surtout les jeunes hommes. Le DSM-5 la classe parmi les troubles de l'image du corps (dysmorphophobie).
- Ces notions aident à repérer des comportements à risque chez des publics sportifs ou très attentifs à leur alimentation, sans coller d'étiquette.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.22

Dans un club d'athlétisme, l'entraîneur vous signale qu'une coureuse de 16 ans a perdu beaucoup de poids depuis la rentrée, qu'elle s'entraîne seule en plus des séances et qu'elle ne mange plus avec le groupe lors des déplacements. a) Classez les signes observés. b) Rédigez la phrase que l'entraîneur peut lui dire. c) Indiquez à qui l'orienter et ce que l'entraîneur ne doit pas faire.

Corrigé

a) Signe **physique** : perte de poids importante ; signe **comportemental** : activité physique en plus et isolement au moment des repas. **b)** « J'ai remarqué que tu t'entraînes beaucoup en plus et que tu ne manges plus avec nous ; je tiens à toi et je m'inquiète. Est-ce qu'on peut en parler ? » **c)** L'orienter vers le médecin du club ou son médecin traitant, et prévenir ses parents (elle est mineure) ; il ne doit pas la peser, commenter son poids devant le groupe, lui interdire l'entraînement sans avis médical ni lui donner un « plan alimentaire ».

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.3.12 et 4.3.13 – Durabilité et TCA

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre dimensions de l'alimentation durable.

2. Quelle quantité de viande rouge le régime de santé planétaire (EAT-Lancet, 2019) prévoit-il environ par

jour ?

3. Quels objectifs d'achats la loi EGalim fixe-t-elle à la restauration collective publique ?
4. Citez trois signes d'alerte d'un TCA.
5. Que fait le diététicien de santé publique face à ces signes ?
6. L'orthorexie est-elle un diagnostic du DSM-5 ?

Corrigé – Point d'étape 4.3.12 et 4.3.13

1. Santé, environnement, économie, culture et société.
2. Environ 14 g par jour, soit environ 100 g par semaine.
3. Au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits biologiques, en valeur d'achat (depuis le 1er janvier 2022).
4. Par exemple : perte de poids rapide, évitement de familles d'aliments, vomissements, activité physique compulsive, isolement au moment des repas, peur intense de grossir.
5. Il en parle en privé, sans juger ni parler de poids, et oriente vers le médecin ou une structure spécialisée ; il ne pose pas de diagnostic.
6. Non : c'est une notion proposée par Steven Bratman (1997), pas un diagnostic.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

4.3.14 Les stratégies alimentaires des ménages en situation de précarité

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M2 S2 §5 et §6 (p. 18 et 19)

Les personnes en situation de précarité ne « mangent pas mal par manque de connaissances » : elles développent des **stratégies** pour faire face à des contraintes fortes (budget, logement, équipement, temps, stress).

Stratégie	Exemples et conséquences
Réduire la qualité pour préserver la quantité	Aliments denses en énergie et bon marché (féculents raffinés, produits gras et sucrés) ; moins de fruits, légumes, poisson
Prioriser les enfants	Les parents (souvent les mères) sautent des repas pour que les enfants mangent
Faire durer	Achats au jour le jour, plats qui « tiennent au corps », recours aux promotions
Recourir à l'aide alimentaire	Épiceries solidaires, colis, restaurants sociaux ; choix limité, parfois honte
Préserver des moments de plaisir	Achat d'aliments « plaisir » pour les enfants : besoin de normalité et de dignité, à respecter

Lien diététique – Ce que cela change pour l'action

Une action en milieu précaire part de ces stratégies, reconnaît les **compétences** des personnes (savoir faire durer un budget est une compétence) et respecte le besoin de **plaisir** et de **normalité** ; elle combine les conseils pratiques avec l'**accès** (épiceries solidaires, chèques, jardins) et la **dignité** (choisir ses produits, participer). Le droit à une alimentation suffisante et choisie est d'ailleurs rappelé par la loi EGalim (2018), qui

a défini la **lutte contre la précarité alimentaire** dans le Code de l'action sociale et des familles.

Construire un budget alimentaire hebdomadaire

Le **budget** est l'un des déterminants les plus puissants des pratiques alimentaires (4.3.4). Pour une famille qui dispose de peu de moyens, le diététicien ne se contente pas de donner des repères : il aide à **construire un budget réaliste**, qui part des menus de la famille et des prix qu'elle paie réellement. Cette démarche valorise une compétence (faire durer un budget) et évite les conseils impossibles à suivre.

Définition – Coefficient budgétaire de l'alimentation

Le **coefficient budgétaire** de l'alimentation est la part des dépenses de consommation d'un ménage consacrée à l'alimentation. En France, il est passé d'environ 35 % en 1960 à environ **20 %** en 2014, restauration comprise (Insee Première n° 1568, 2015). En 2025, les seuls produits alimentaires et boissons non alcoolisées pèsent 12,5 % de la dépense de consommation des ménages (Insee, 29 mai 2026). Il est plus élevé dans les ménages modestes : plus le revenu est faible, plus l'alimentation pèse lourd, et plus elle sert de **variable d'ajustement** quand le loyer ou l'énergie augmentent.

Méthode pas à pas – Cinq étapes pour construire le budget avec la famille

1. Partir des menus de la semaine : la famille indique ce qu'elle mange habituellement ; on construit avec elle une semaine de menus simples, appréciés, qui respectent les repères (fruits et légumes, féculents complets de temps en temps, légumes secs, produits laitiers).

2. Établir la liste de courses à partir des menus, en quantités (kg, litres, pièces), en tenant compte de ce qui reste dans les placards.

3. Relever les prix que la famille paie réellement (ticket de caisse, drive, marché) : un budget construit sur des prix « de catalogue » ne sert à rien.

4. Calculer le total, le coût par personne et par jour, et la répartition par groupe d'aliments.

5. Ajuster ensemble : repérer les postes où l'on peut économiser sans perdre en qualité (légumes secs, surgelés nature, produits de saison, marques de distributeur), et ceux qu'il faut préserver (fruits et légumes, produits laitiers pour les enfants).

Calcul détaillé – Le budget d'une semaine pour une famille de quatre personnes (prix fictifs, octobre 2026)

Liste de courses : pâtes 2 kg (2,80 €) ; riz 1 kg (1,90 €) ; lentilles vertes 1 kg (2,60 €) ; pois chiches secs 500 g (1,60 €) ; farine 1 kg (0,95 €) ; 7 baguettes (7,70 €) ; lait 6 L (6,30 €) ; 16 yaourts nature (3,80 €) ; fromage (4,90 €) ; 12 œufs (3,40 €) ; filets de poulet 1 kg (8,70 €) ; 4 boîtes de sardines (4,20 €) ; légumes frais 5 kg (9,50 €) ; légumes surgelés nature (4,40 €) ; fruits 4 kg (8,80 €) ; huile 1 L (2,40 €) ; beurre 250 g (2,40 €) ; divers (épices, sel, sucre, café : 3,00 €).

- **Total** : 79,35 € pour la semaine.
- **Par personne et par jour** : 79,35 / (4 × 7) = 79,35 / 28 = **2,83 €**.
- **Fruits et légumes** : 9,50 + 4,40 + 8,80 = 22,70 €, soit 22,70 / 79,35 × 100 = **28,6 %** du budget.
- **Féculents et pain** : 2,80 + 1,90 + 0,95 + 7,70 = 13,35 €, soit **16,8 %**.
- **Viande, poisson, œufs et légumes secs** : 2,60 + 1,60 + 3,40 + 8,70 + 4,20 = 20,50 €, soit **25,8 %**.
- **Produits laitiers** : 6,30 + 3,80 + 4,90 = 15,00 €, soit **18,9 %** ; **matières grasses** : 4,80 €, soit **6,0 %** ; **divers** : 3,00 €, soit **3,8 %**.
- Vérification : 22,70 + 13,35 + 20,50 + 15,00 + 4,80 + 3,00 = **79,35 €** ✓ (la somme des pourcentages fait 99,9 % à cause des arrondis).
- **Par mois** : 79,35 × 52 / 12 = **343,85 €**.

Interprétation : avec moins de 3 € par personne et par jour, la famille peut manger varié, à condition de cuisiner les produits de base. Les fruits et légumes représentent plus du quart du budget : c'est un poste à **protéger**, en jouant sur la saison, le marché de fin de journée et les surgelés nature.

Comparer le prix des sources de protéines

Le prix au kilo est trompeur : un aliment bon marché peut contenir peu de protéines, et inversement. Pour comparer des sources de protéines, on calcule le **coût de 10 g de protéines**.

Calcul détaillé – Le coût de 10 g de protéines (Ciqual 2025, prix fictifs de la liste ci-dessus)

Formule : coût de 10 g de protéines = prix payé × 10 / quantité de protéines achetée (en g).

- **Lentilles vertes sèches** (25,1 g de protéines pour 100 g) : 1 000 g × 25,1 / 100 = 251 g de protéines ; 2,60 × 10 / 251 = **0,10 €**.
- **Pois chiches secs** (20,5 g pour 100 g) : 500 × 20,5 / 100 = 102,5 g ; 1,60 × 10 / 102,5 = **0,16 €**.
- **Filet de poulet cru** (23,4 g pour 100 g) : 1 000 × 23,4 / 100 = 234 g ; 8,70 × 10 / 234 = **0,37 €**.
- **Œufs** (12,8 g pour 100 g ; 12 œufs ≈ 600 g sans coquille) : 600 × 12,8 / 100 = 76,8 g ; 3,40 × 10 / 76,8 = **0,44 €**.
- **Sardines à l'huile égouttées** (23,3 g pour 100 g ; 4 boîtes de 95 g égouttés = 380 g) : 380 × 23,3 / 100 = 88,5 g ; 4,20 × 10 / 88,5 = **0,47 €**.

Interprétation : les légumes secs fournissent des protéines **trois à quatre fois moins chères** que le poulet, et apportent en plus des fibres et du fer. Les sardines, plus chères par gramme de protéines, gardent un intérêt pour leurs acides gras oméga-3 et leur vitamine D : le choix ne se fait pas sur le seul prix.

Attention – Ce que le budget ne dit pas

Un budget calculé ne tient compte ni du **temps** de préparation, ni de l'**équipement** (une famille hébergée à l'hôtel n'a souvent qu'une plaque ou un micro-ondes), ni de l'**énergie** (une cuisson de légumes secs de 45 minutes a un coût), ni des **goûts** des enfants. On vérifie toujours ces contraintes (4.3.4) avant de proposer une liste. Les prix d'un exemple sont **fictifs** ou datés : en atelier, on les remplace par ceux relevés avec les participants.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.23

Une mère seule avec deux enfants dispose de 60 € par semaine pour l'alimentation. a) Calculez le budget par personne et par jour. b) Elle achète chaque semaine 1,5 kg de steaks hachés à 9,80 €/kg (protéines : 18 g pour 100 g, valeur fictive arrondie). Calculez le coût de 10 g de protéines et comparez avec les lentilles du calcul ci-dessus. c) Proposez deux ajustements qui respectent les goûts de la famille.

Corrigé

a) 60 / (3 × 7) = 60 / 21 = **2,86 €** par personne et par jour. **b)** Coût : 1,5 × 9,80 = 14,70 € ; protéines : 1 500 × 18 / 100 = 270 g ; 14,70 × 10 / 270 = **0,54 €** pour 10 g, soit plus de cinq fois le coût des lentilles (0,10 €). Les steaks hachés représentent 14,70 / 60 × 100 = **24,5 %** du budget. **c)** Garder les steaks hachés deux fois par semaine (les enfants les aiment) et préparer un jour un hachis parmentier où la moitié de la viande est remplacée par des lentilles ; prévoir un plat d'œufs (omelette aux pommes de terre) ; utiliser l'économie pour acheter des fruits de saison pour les goûters.

Précarité, pauvreté et aide alimentaire : les repères

Définition – Précarité (Joseph Wresinski, 1987)

Selon le rapport du fondateur d'ATD Quart Monde au Conseil économique et social (publié au *Journal officiel* en 1987), la précarité est « l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux ». Quand elle touche plusieurs domaines et dure, elle conduit à la **grande pauvreté**.

La pauvreté a plusieurs visages : **monétaire** (niveau de vie inférieur à 60 % du niveau de vie médian : 1 337 € par mois en 2024, voir le chapitre 3), **en conditions de vie** (retards de paiement, restrictions, logement difficile), mais aussi manque de **capacités** (savoirs, langue, réseau), fragilité **familiale** (familles monoparentales ou nombreuses) et renoncement aux **soins**.

- **Aide alimentaire** : le programme européen d'aide aux plus démunis (PEAD) est créé en **1987** pour distribuer les surplus agricoles ; il est remplacé par le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD, 2014-2020), puis intégré au **Fonds social européen plus** (FSE+, 2021-2027). En France, elle passe par des associations comme les **Restos du Cœur** (créés en 1985), le Secours populaire, la Croix-Rouge et les banques alimentaires. Depuis 2018 (loi EGalim), le Code de l'action sociale et des familles parle de **lutte contre la précarité alimentaire**, qui vise aussi la dignité et le choix ; le programme « **Mieux manger pour tous** » finance depuis 2023 des produits frais et de qualité.
- **Pauvreté et obésité** : l'obésité est plus fréquente dans les milieux modestes. Les causes sont multiples : prix (les calories des aliments gras et sucrés coûtent moins cher), manque d'équipement ou de temps pour cuisiner, stress, offre du quartier, moins d'activité physique encadrée. Il ne s'agit pas d'un « choix » ou d'une « culture du plaisir » propre à ces familles : on parle d'**inégalités sociales de santé**.

4.3.15 Les pratiques alimentaires religieuses en détail

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Connaître les principales règles alimentaires religieuses permet de **respecter** les participants et d'**adapter** recettes et menus, sans jamais supposer qu'une personne pratique du fait de son origine : on **demande** (fiche-outil O4.1).

Religion	Règles alimentaires principales	Conséquences pratiques
Islam	Interdiction du porc et de ses dérivés (gélatine de porc, saindoux), de l'alcool (y compris en cuisine) ; viande halal (abattage rituel) pour les pratiquants ; jeûne du Ramadan (de l'aube au coucher du soleil, pendant un mois lunaire)	Recettes sans porc ni alcool ; vérifier les étiquettes (gélatine, arômes) ; viande halal ou plat végétarien ; adaptation des horaires pendant le Ramadan (repas de rupture équilibré, hydratation)
Judaïsme	Règles de la cacheroute : animaux autorisés (ruminants aux sabots fendus, poissons à nageoires et écailles), interdiction du porc et des fruits de mer, abattage rituel, séparation du lait et de la viande (ustensiles distincts) ; jeûnes (Kippour) ; Pâque (pas de pain levé)	Plats végétariens ou poissons autorisés ; ne pas mélanger viande et produits laitiers ; en collectivité, repas casher fournis par des prestataires agréés
Christianisme	Selon les traditions : abstinence de viande le vendredi (surtout pendant le Carême chez les catholiques pratiquants) ; jeûnes plus nombreux chez les orthodoxes (périodes sans produits animaux)	Proposer du poisson ou un plat végétarien le vendredi si demandé ; adapter pendant les jeûnes orthodoxes
Hindouisme	Respect de la vache (pas de bœuf) ; végétarisme fréquent ; parfois exclusion des œufs, de l'ail et de l'oignon selon les courants	Plats végétariens ; vérifier les ingrédients
Bouddhisme	Végétarisme fréquent mais non obligatoire selon les écoles	Proposer une option végétarienne

Religion	Règles alimentaires principales	Conséquences pratiques
Sikhisme, jaïnisme	Viande abattue rituellement interdite chez les sikhs ; végétarisme strict, parfois sans légumes-racines, chez les jaïns	S'informer auprès des personnes

Attention – Laïcité et restauration collective

En France, la **laïcité** n'oblige pas la restauration collective publique à proposer des menus confessionnels, mais rien ne l'interdit ; de nombreuses collectivités proposent un **plat de substitution** les jours où du porc est servi, ou une option **végétarienne** quotidienne, qui convient au plus grand nombre. Pour un atelier, la solution la plus simple et la plus inclusive est souvent une recette **végétarienne ou à base de poisson ou de volaille**, sans alcool ni porc, présentée sans référence religieuse.

Anticiper le calendrier des fêtes et des jeûnes

Une action d'éducation ou un menu de restauration collective se planifient des mois à l'avance (voir aussi la méthode « Préparer un atelier interculturel respectueux » au chapitre 3). Consulter un **calendrier des fêtes religieuses** de l'année évite de programmer un atelier cuisine en plein jeûne, ou un repas à thème le jour d'une fête importante pour une partie des convives.

Fête ou période	Tradition	Pratiques alimentaires associées	Conséquence pour l'organisation
Ramadan, puis Aïd el-Fitr	Islam	Jeûne de l'aube au coucher du soleil pendant un mois ; rupture du jeûne (dattes, eau, soupe) ; pâtisseries à l'Aïd	Pas d'atelier dégustation en journée ; ateliers possibles en soirée autour de la rupture du jeûne
Aïd el-Kébir (Aïd al-Adha)	Islam	Sacrifice d'un mouton, repas familiaux	Absences possibles ; ne pas fixer d'évaluation ce jour-là
Carême, puis Pâques	Christianisme	Abstinence de viande certains jours, parfois jeûne ; repas festif à Pâques	Proposer poisson ou plat végétarien le vendredi si demandé
Pessah (Pâque juive)	Judaïsme	Pain azyme (matsa), aucun produit levé pendant huit jours	Prévoir une alternative au pain et aux féculents levés
Yom Kippour	Judaïsme	Jeûne complet d'environ 25 heures	Pas de repas collectif ce jour-là pour les personnes concernées
Diwali	Hindouisme, sikhisme, jaïnisme	Confiseries et plats festifs, souvent végétariens	Occasion de découvrir des recettes, en respectant les interdits
Nouvel An lunaire	Chine, Vietnam, Corée	Repas familiaux, raviolis, gâteaux de riz	Thème possible d'atelier interculturel

Calcul détaillé – Pourquoi la date du Ramadan avance chaque année

Le calendrier musulman est **lunaire** : douze mois lunaires durent environ **354,4 jours**, contre **365,25 jours** pour l'année solaire.

- Décalage annuel : 365,25 − 354,4 = **10,9 jours** environ ; le Ramadan commence donc environ **11 jours plus tôt** chaque année.
- Retour à la même saison : 365,25 / 10,9 ≈ **33,5 ans**.
- Exemple : le Ramadan a commencé vers le 18 février 2026 ; on peut prévoir un début vers le **7 ou 8 février 2027**, puis vers la fin janvier 2028. En 2030, il commencera **deux fois** dans la même année civile (début janvier et fin décembre).

Interprétation : la date exacte dépend de l'observation de la lune et n'est confirmée que quelques jours avant ; pour planifier, on retient une fourchette de plus ou moins deux jours. La durée du jeûne dépend de la saison : environ 12 à 13 heures en février en France métropolitaine, mais 17 à 19 heures lorsque le Ramadan

tombait en juin (années 2015 à 2018).

Méthode pas à pas – Conseiller une personne qui jeûne pendant le Ramadan

1. Ne pas juger le choix de jeûner : on part de la pratique de la personne et on cherche à la rendre la plus sûre possible.

2. Repérer les situations à risque : diabète (surtout traité par insuline ou sulfamides), maladie rénale, grossesse et allaitement, personne âgée fragile, enfant, sportif à fort entraînement. Le jeûne n'est pas une obligation religieuse pour les personnes malades ; la décision se prend avec le **médecin**, et les recommandations internationales (IDF-DAR, 2021) classent le risque des personnes diabétiques.

3. Structurer les prises de la nuit : une rupture du jeûne légère (eau, dattes, soupe), un vrai repas, une collation en soirée et un repas avant l'aube (**shour**) qu'il ne faut pas sauter.

4. Penser à l'hydratation : boire régulièrement entre le coucher et le lever du soleil, plutôt qu'une grande quantité d'un coup ; limiter le café et le thé très sucré.

5. Limiter les excès : fritures et pâtisseries très sucrées de la rupture du jeûne, repas trop copieux et tardif qui gêne le sommeil.

Calcul détaillé – Répartir 2 400 kcal sur la nuit pour un lycéen qui jeûne (repères indicatifs)

Répartition proposée : rupture du jeûne 15 %, repas du soir 40 %, collation de soirée 10 %, shour 35 %.

- Rupture du jeûne : 2 400 × 15 / 100 = **360 kcal** (un grand verre d'eau, 3 dattes, un bol de chorba aux lentilles).
- Repas du soir : 2 400 × 40 / 100 = **960 kcal** (plat complet avec légumes, féculent et viande ou légumineuses, pain, fruit).
- Collation de soirée : 2 400 × 10 / 100 = **240 kcal** (yaourt, fruit, quelques amandes).
- Shour : 2 400 × 35 / 100 = **840 kcal** (pain complet, fromage ou œufs, flocons d'avoine au lait, fruit, eau).
- Vérification : 360 + 960 + 240 + 840 = **2 400 kcal** ✓.
- Hydratation : pour boire 1,5 L entre 18 h et 6 h, il faut environ 1 500 / 250 = **6 verres** de 250 mL, soit un verre toutes les deux heures de veille.

Interprétation : le shour, riche en féculents complets, en protéines et en eau, aide à tenir la journée ; le sauter oblige à un jeûne plus long et favorise la fatigue, les maux de tête et la baisse d'attention en cours.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.24

Une association de quartier prévoit un cycle de six ateliers cuisine le mercredi à 14 h, du 27 janvier au 3 mars 2027, avec dégustation. La moitié des participantes pratiquent le Ramadan. a) Que risque-t-il de se passer ? b) Proposez deux solutions. c) Pourquoi faut-il vérifier la date exacte quelques jours avant ?

Corrigé

a) Le Ramadan devrait commencer vers le 7 ou 8 février 2027 : quatre ateliers sur six tomberaient en période de jeûne ; les participantes concernées ne pourraient pas goûter, se sentiraient exclues ou ne viendraient pas. **b)** Décaler le cycle (par exemple après l'Aïd el-Fitr, vers mi-mars 2027) ; ou garder la période mais placer les ateliers en fin d'après-midi, avec des recettes « à emporter » pour la rupture du jeûne, et un atelier sur le thème « un Ramadan équilibré » construit avec les participantes. **c)** Le début du mois dépend de l'observation de la lune : la date annoncée à l'avance peut varier d'un jour ou deux.

4.3.16 La dégustation et l'analyse sensorielle au service de l'éducation

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Le goût est un apprentissage (4.4.1) ; l'**analyse sensorielle** fournit des méthodes simples pour faire découvrir les aliments, développer le vocabulaire et évaluer l'acceptation d'une recette (lien avec la compétence C3.2 et la fiche F9).

Méthode	Principe	Usage en atelier
Épreuve descriptive	Décrire l'aspect, l'odeur, la texture, les saveurs (sucré, salé, acide, amer, umami) et les arômes	Éducation sensorielle, vocabulaire, plaisir
Échelle hédonique	Noter son appréciation (de 1 « je n'aime pas du tout » à 5 « j'aime beaucoup », ou smileys)	Évaluer l'acceptation d'une recette
Test triangulaire	Trois échantillons dont deux identiques : trouver l'intrus	Montrer qu'on ne perçoit pas toujours une réduction de sel ou de sucre
Classement	Classer des échantillons (du moins au plus sucré)	Prendre conscience des teneurs (yaourts, jus)

Exemple – Calcul détaillé : acceptation d'une recette de légumineuses (échelle hédonique en 5 points)

Vingt participants goûtent un houmous de pois chiches maison. Notes : 5 (×6), 4 (×7), 3 (×4), 2 (×2), 1 (×1).

- Vérification : 6 + 7 + 4 + 2 + 1 = **20** . ✓
- Somme des notes : 5 × 6 + 4 × 7 + 3 × 4 + 2 × 2 + 1 × 1 = 30 + 28 + 12 + 4 + 1 = **75** ; moyenne : 75 / 20 = **3,75 / 5**.
- **Taux d'acceptation** (notes 4 et 5) : (6 + 7) / 20 × 100 = **65 %** ; rejet (notes 1 et 2) : 3 / 20 = **15 %**.
- Médiane (valeurs classées : 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5) : moyenne des 10e et 11e valeurs = (4 + 4) / 2 = **4**.

Interprétation : recette bien acceptée ; on peut l'intégrer au livret ; les remarques des personnes ayant mis 1 ou 2 (« trop d'ail », « texture pâteuse ») servent à l'ajuster.

Exemple – Calcul détaillé : un test triangulaire sur la réduction du sel

Pour montrer qu'une soupe moins salée reste appréciée, on présente à 24 participants trois verrines, dont deux identiques (soupe habituelle) et une avec 30 % de sel en moins. Par hasard, la probabilité de trouver l'intrus est de 1 sur 3 : sur 24 personnes, on attend donc 24 / 3 = **8** bonnes réponses dues au seul hasard. Résultat : **10** personnes trouvent l'intrus, soit 10 / 24 × 100 = **41,7 %**, à peine plus que le hasard (33,3 %). Pour conclure à une différence perçue avec 24 participants, il faudrait au moins **13** bonnes réponses (seuil des tables de l'analyse sensorielle, norme ISO 4120, risque de 5 %). **Conclusion** : la réduction de 30 % du sel n'est pas perçue par la majorité : un argument concret pour cuisiner moins salé.

4.3.17 Repères sur quelques cultures culinaires

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Connaître les grandes lignes de quelques cultures culinaires présentes en France aide à **valoriser** les savoir-faire des participants et à construire l'équilibre **à partir** de leurs plats (chapitre 3, interculturalité). Ces repères sont des **tendances générales** : chaque famille a ses propres pratiques, qu'on découvre en l'écoutant.

Cuisine	Aliments et plats de base	Atouts nutritionnels	Points de vigilance et adaptations
Maghreb	Semoule, pain, légumes (couscous, tajines), pois chiches, lentilles (chorba, harira), épices, huile d'olive	Légumes et légumineuses très présents, épices permettant de saler moins	Pâtisseries très sucrées lors des fêtes, thé très sucré, fritures ; garder la richesse en légumes et légumineuses
Afrique de l'Ouest	Riz, mil, manioc, igname, plantain ; sauces (arachide, tomate, feuilles), poisson, gombo	Légumes-feuilles, poisson, plats complets	Sauces riches en huile, cubes de bouillon salés, boissons sucrées ; réduire les cubes, mesurer l'huile, garder les légumes-feuilles
Turquie	Boulgour, pain, yaourt, légumes farcis, lentilles (mercimek), huile d'olive	Produits laitiers fermentés, légumes, céréales	Pâtisseries au sirop, pain blanc en grande quantité
Asie du Sud (Inde, Sri Lanka, Pakistan)	Riz, galettes (chapati), lentilles (dal), légumes au curry, yaourt, épices	Végétarisme fréquent, légumineuses quotidiennes	Ghee et fritures, desserts sucrés ; risque de diabète élevé dans ces populations : vigilance sur les quantités de riz blanc
Asie de l'Est et du Sud- Est	Riz, nouilles, légumes sautés, soja (tofu), poisson, bouillons	Peu de produits laitiers mais beaucoup de légumes, tofu	Sauces très salées (soja, poisson), apports en calcium à surveiller
Antilles, Guyane, Réunion	Riz, légumineuses (pois rouges, lentilles), racines (igname, dachine), poisson, fruits tropicaux, cari	Légumineuses et fruits	Boissons sucrées et sirops, fritures (accras), sel ; prévalence élevée du diabète et de l'obésité en outre-mer
Europe de l'Est	Pommes de terre, chou, betterave, céréales (sarrasin), produits laitiers fermentés, charcuteries	Légumes de garde, fermentés	Charcuteries et sel ; garder les soupes de légumes

Exemple – Adapter un plat traditionnel sans le dénaturer : le mafé

Recette familiale pour 6 : 1 kg de bœuf, 250 g de pâte d'arachide, 2 cubes de bouillon, 10 cL d'huile, 500 g de légumes, 600 g de riz blanc (cru). Propositions construites **avec** la participante : 600 g de viande et 400 g de pois chiches (cuits) au lieu de 1 kg de viande ; 1 cube au lieu de 2 (épices et oignon pour le goût) ; 4 cL d'huile (la pâte d'arachide apporte déjà des lipides) ; 900 g de légumes (carottes, chou, patate douce) ; riz en partie complet.

- **Sel** : un cube de bouillon contient environ 4 à 5 g de sel (selon les marques, à lire sur l'étiquette) ; passer de 2 à 1 cube réduit d'environ 4,5 g le sel du plat, soit 4,5 / 6 = **0,75 g** par portion.
- **Huile** : de 10 à 4 cL = 6 cL en moins ≈ 54 g d'huile (densité ≈ 0,9) ≈ 54 × 9 = **486 kcal** en moins pour le plat, soit 486 / 6 = **81 kcal** par portion.
- **Légumes** : de 500 à 900 g, soit de 83 à **150 g** par portion.

Principe : on garde le **nom**, le **goût** et la **fonction sociale** du plat (repas de fête, transmission) ; on ajuste les quantités, sans « interdire » ; la participante reste maîtresse de sa recette.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.3.14 à 4.3.17 – Précarité, religions, dégustation, cultures

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois stratégies alimentaires des ménages en situation de précarité.
2. Que fait-on avant d'adapter une recette aux pratiques religieuses d'un groupe ?
3. La laïcité oblige-t-elle une cantine publique à proposer des menus confessionnels ?
4. Comment calcule-t-on le taux d'acceptation d'une recette avec une échelle hédonique ?
5. Dans un test triangulaire, quelle est la probabilité de trouver l'intrus par hasard ?
6. Citez deux principes pour adapter un plat traditionnel sans le dénaturer.

Corrigé – Point d'étape 4.3.14 à 4.3.17

1. Réduire la qualité pour préserver la quantité ; prioriser les enfants ; faire durer ; recourir à l'aide alimentaire ; préserver des moments de plaisir.
2. On demande aux participants ce qu'ils mangent et ne mangent pas (fiche O4.1), sans supposer une pratique à partir de l'origine.
3. Non, mais elle ne l'interdit pas ; beaucoup de collectivités proposent un plat de substitution ou une option végétarienne.
4. Nombre de notes 4 et 5 divisé par le nombre de participants, multiplié par 100.
5. Une chance sur trois (33,3 %).
6. Garder le nom, le goût et la fonction sociale du plat ; ajuster les quantités (huile, sel, viande, légumes) avec la personne, sans interdire.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

4.3.18 Fil rouge : les pratiques alimentaires des familles des Tilleuls

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès a pris en compte

- **Rôles de l'acte alimentaire** : pour les familles, le repas est d'abord un moment de **générosité** et de **plaisir** partagé ; Inès a donc choisi des plats copieux et conviviaux (parmentier, crumble) plutôt que des « petites portions diététiques ».
- **Pratiques religieuses** : 7 familles sur 12 mangent halal ; les recettes des ateliers sont **sans porc** et sans alcool, la viande éventuelle est achetée halal ; l'atelier 5 a été placé hors période de Ramadan, et une fiche « Ramadan équilibré » a été demandée par les familles pour l'année suivante.
- **Régulation** : lors de l'atelier goûters, les parents ont découvert l'**échelle de la faim** pour aider les enfants à distinguer faim et envie.
- **Syncrétisme** : les recettes du monde (tiep, chorba, dal) ont été adaptées avec des légumes de saison achetés au marché.
- **Évolutions** : plusieurs familles utilisent des plateformes de livraison le week-end ; Inès a proposé des recettes « aussi rapides qu'une livraison » (moins de 20 minutes).

Fil rouge – centre social des tilleuls – Compléments : rythmes, enfants et durabilité aux Tilleuls

- **Rythmes** : au questionnaire, 21 parents sur 48 (43,8 %) déclarent que leurs enfants ne prennent pas de petit-déjeuner au moins 2 jours par semaine d'école ; le goûter est souvent pris devant un écran. L'atelier 4 « goûters et boissons » a intégré un temps sur le **petit-déjeuner rapide** (bol de lait, pain, fruit : 0,55 € par enfant).
- **Partage des responsabilités** : lors de l'atelier parents-enfants, Inès a présenté le modèle de Satter ; plusieurs parents ont témoigné d'un soulagement (« Je n'ai plus à me battre pour qu'il finisse »).
- **Exposition répétée** : le centre de loisirs du centre social a proposé une fois par semaine, pendant 8 semaines, un légume « découverte » au goûter (carotte, chou-fleur, radis) : 9 enfants sur 25 goûtaient la 1re semaine (36 %), 18 sur 25 la 8e (72 %).
- **Durabilité** : l'atelier « repas complet petit budget » a comparé le parmentier de lentilles (0,68 € la portion,

environ 0,04 kg CO2e pour 40 g de lentilles) à un hachis parmentier au bœuf (environ 1,20 € la portion, environ 2 kg CO2e pour 75 g de bœuf, ordre de grandeur) : le message « bon pour la santé, le porte-monnaie et la planète » a été retenu par le groupe comme slogan du livret.

4.3.19 Six cas guidés pour s'entraîner à l'analyse d'un comportement alimentaire

Module · Référentiel et guide : voir 4.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Ces six cas reprennent les notions du chapitre dans l'ordre attendu par le jury : décrire la situation avec des chiffres, l'expliquer avec les notions du cours, puis proposer une action argumentée qui respecte le public. Essayez de répondre avant de lire chaque corrigé.

Cas guidé 1 – « Manger sans culpabilité » dans une association de quartier (données fictives)

Une association de quartier propose un groupe de parole à des femmes de 30 à 60 ans. L'animatrice sollicite un diététicien car les échanges tournent souvent autour des régimes. Un questionnaire anonyme est rempli par les **18 participantes**.

- « J'ai déjà fait au moins trois régimes » : 12 ; « je me sens coupable après avoir mangé certains aliments » : 11 ; « après un écart, je saute le repas suivant » : 8 ; « je mange quand je suis fatiguée ou contrariée » : 14.
- Verbatims : « Le pain, je n'y touche plus, et puis un soir je mange toute la baguette. » ; « Depuis trente ans, je suis au régime, et j'ai pris 15 kilos. » ; « Le soir, quand les enfants sont couchés, c'est mon moment, avec le chocolat. »

Questions – Cas guidé 1

1. Calculez le pourcentage de participantes concernées par chaque réponse.

2. Analysez la situation avec le cercle de la restriction cognitive et les styles alimentaires.

3. Proposez le déroulement d'une séance de 1 h 30 qui ne parle pas de poids.

4. Indiquez les précautions à prendre et les signes qui justifieraient une orientation.

Corrigé – Cas guidé 1

1. Au moins trois régimes : 12 / 18 = **66,7 %** ; culpabilité : 11 / 18 = **61,1 %** ; repas sauté après un écart : 8 / 18 = **44,4 %** ; manger sous l'effet de la fatigue ou de la contrariété : 14 / 18 = **77,8 %**.

2. Les deux tiers des participantes ont une longue histoire de régimes : c'est le terrain de la **restriction cognitive** (Herman et Polivy, 1975). Les verbatims montrent le cycle complet : interdit (le pain), **désinhibition** (« toute la baguette »), **culpabilité** (61,1 %), compensation (44,4 % sautent un repas), puis reprise de poids (« 15 kilos en trente ans de régime »). Le style **émotionnel** est aussi très présent (77,8 %) : le chocolat du soir est un moment de récompense et de détente, à respecter.

3. Accueil et règles du groupe (bienveillance, confidentialité) : 10 min. Photolangage « ce que manger représente pour moi » : 20 min. Présentation du cercle de la restriction à partir de leurs propres phrases, sans jugement : 15 min. Dégustation en pleine conscience d'un carré de chocolat et d'un morceau de pain, avec l'échelle de la faim et de la satiété : 25 min. Échange : « que pourrais-je essayer cette semaine ? » (un seul petit pas, choisi par chacune) : 15 min. Clôture : 5 min.

4. Ne pas peser, ne pas parler de poids ni de calories, ne pas présenter d'aliment « interdit » ; respecter le rythme de chacune ; ne pas faire de la dégustation une nouvelle règle. Orienter individuellement, en lien avec le médecin traitant, une participante qui décrit des crises fréquentes avec perte de contrôle, des vomissements, une détresse importante ou une perte de poids rapide (signes possibles de TCA).

Cas guidé 2 – Le goûter de l'accueil périscolaire (données fictives)

Un accueil périscolaire reçoit 28 enfants de 6 à 10 ans quatre soirs par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi), 36 semaines par an. Le goûter est fourni par la commune pour 0,45 € par enfant. Une stagiaire a observé **12 goûters** avec une grille.

- Enfants assis : 5 goûters ; un adulte assis avec les enfants : 2 ; eau proposée : 4 ; goûter composé uniquement de biscuits industriels : 9. Durée moyenne : 8 minutes.
- Les animateurs disent : « On n'a pas le temps, il faut lancer les activités. » ; « Les enfants préfèrent les biscuits, au moins ils mangent. »

Questions – Cas guidé 2

1. Calculez le pourcentage de goûters pour chaque élément observé et le budget annuel du goûter.

2. Analysez la situation avec les rythmes alimentaires et le partage des responsabilités.

3. Proposez un goûter type au même coût et deux changements d'organisation.

4. Proposez deux indicateurs pour évaluer le changement.

Corrigé – Cas guidé 2

1. Enfants assis : 5 / 12 = **41,7 %** ; adulte assis : 2 / 12 = **16,7 %** ; eau proposée : 4 / 12 = **33,3 %** ; biscuits seuls : 9 / 12 = **75,0 %**. Budget annuel : 36 semaines × 4 soirs = 144 soirs ; 28 × 0,45 × 144 = **1 814,40 €**.

2. Le goûter est une vraie prise chez l'enfant (10 à 15 % de l'énergie de la journée) qui comble le long écart entre le déjeuner et le dîner ; pris debout en 8 minutes, composé de biscuits seuls, il ressemble à du **grignotage** plutôt qu'à un repas : peu rassasiant, il prépare le grignotage de fin de journée. Le **partage des responsabilités** n'est pas respecté côté adulte : le « quoi » (offre variée), le « où » (assis) et l'ambiance (adulte présent) relèvent des animateurs. L'argument « au moins ils mangent » confond quantité et qualité.

3. Goûter type : 40 g de pain (0,18 €), 10 g de chocolat noir (0,08 €) et une demi-pomme ou une clémentine (0,18 €), avec de l'eau : **0,44 €**, dans le budget de 0,45 €. On peut alterner avec un produit laitier (yaourt, fromage) et un fruit. Organisation : un goûter assis de 20 minutes avec un animateur par table qui goûte avec les enfants ; les enfants distribuent et rangent à tour de rôle (participation).

4. Part des goûters où les enfants sont assis et où un adulte goûte avec eux (même grille, 12 goûters observés au trimestre suivant) ; part des goûters composés d'au moins deux groupes d'aliments dont un fruit ou un produit laitier (relevé des achats).

Cas guidé 3 – Le restaurant d'un établissement et service d'aide par le travail (données fictives)

Un ESAT emploie **60 travailleurs** en situation de handicap (handicap intellectuel ou psychique pour la plupart), qui déjeunent au self de l'établissement. La directrice s'inquiète de la prise de poids de plusieurs travailleurs depuis l'arrivée d'un traitement médicamenteux, de grignotages pendant les pauses et de repas pris très vite. Un questionnaire en version « facile à lire et à comprendre » (FALC) a été rempli avec l'aide des moniteurs.

- « Je finis toujours mon assiette » : 27 ; « je mange en moins de 10 minutes » : 21 ; « je m'achète des gâteaux ou des chips pour les pauses » : 33 ; « je fais mes courses seul » : 18 ; « j'aimerais apprendre à cuisiner » : 41.
- Un moniteur : « Certains prennent trois desserts, ils ne savent pas s'arrêter. » Une infirmière : « Plusieurs traitements augmentent l'appétit. »

Questions – Cas guidé 3

1. Calculez le pourcentage de travailleurs concernés par chaque réponse.

2. Identifiez les déterminants du comportement alimentaire de ce public, en citant au moins quatre familles.

3. Proposez trois actions adaptées (environnement du self, compétences, pauses).

4. Indiquez deux précautions éthiques et l'adaptation des supports de communication.

Corrigé – Cas guidé 3

1. Finir son assiette : 27 / 60 = **45,0 %** ; manger en moins de 10 minutes : 21 / 60 = **35,0 %** ; achats de gâteaux ou de chips pour les pauses : 33 / 60 = **55,0 %** ; courses seul : 18 / 60 = **30,0 %** ; souhait d'apprendre à cuisiner : 41 / 60 = **68,3 %**.

2. Biologiques : traitements qui augmentent l'appétit (avis de l'infirmière). **Cognitifs** : difficulté à repérer la satiété ou à anticiper, besoin de supports adaptés (FALC). **Environnementaux** : self en libre-service avec plusieurs desserts accessibles, distributeur ou commerce proche pour les pauses, repas pris très vite (35,0 %). **Sociaux** : habitude de « finir l'assiette » (45,0 %), normes du groupe. **Psychologiques** : plaisir et récompense dans une journée de travail, ennui pendant les pauses. **Économiques** : petit budget, achats d'aliments bon marché et denses en énergie.

3. Self : un seul dessert sur le plateau, fruit en libre accès, portions adaptées avec possibilité de se resservir en légumes ; une durée de repas d'au moins 30 minutes, avec des moniteurs qui mangent à table. Compétences : un atelier cuisine mensuel avec recettes en images, en lien avec l'autonomie (68,3 % le souhaitent), et une sortie « courses » accompagnée. Pauses : une collation proposée par l'ESAT (fruit, pain, laitage) et une fontaine à eau, plutôt que des achats non prévus.

4. Ne jamais stigmatiser le poids ni faire de pesée collective ; respecter les choix et l'autonomie des travailleurs, qui sont des adultes ; travailler avec l'équipe médicale pour les effets des traitements, sans donner de conseils individuels de régime. Supports : FALC (phrases courtes, pictogrammes, photos des aliments et des portions), consignes testées avec quelques travailleurs, participation des travailleurs à la conception.

Cas guidé 4 – Les internes d'un lycée agricole (données fictives)

L'infirmière d'un lycée agricole signale des malaises en cours le matin. Un questionnaire est rempli par les **96 internes** de 15 à 18 ans.

- « Je saute le petit-déjeuner au moins trois jours par semaine » : 38 ; « je me couche après minuit au moins trois soirs par semaine » : 41 ; « je grignote dans ma chambre le soir (gâteaux, chips, sodas) » : 57 ; « je n'aime pas ce qui est servi au self le soir » : 22.
- Le petit-déjeuner est servi de 6 h 45 à 7 h 15 ; les cours commencent à 8 h ; les jeunes achètent leurs provisions le dimanche soir avant de rentrer à l'internat.
- Verbatims : « À 6 h 45, je n'ai pas faim. » ; « Le soir, on se retrouve dans une chambre avec des gâteaux, c'est notre moment. »

Questions – Cas guidé 4

1. Calculez le pourcentage d'internes concernés par chaque réponse.

2. Analysez la situation avec les rythmes alimentaires, la régulation et les déterminants.

3. Proposez trois actions complémentaires, dont au moins une qui agit sur l'environnement.

4. Proposez deux indicateurs d'évaluation.

Corrigé – Cas guidé 4

1. Petit-déjeuner sauté : 38 / 96 = **39,6 %** ; coucher après minuit : 41 / 96 = **42,7 %** ; grignotage le soir : 57 / 96 = **59,4 %** ; repas du soir peu apprécié : 22 / 96 = **22,9 %**.

2. Un enchaînement classique des **rythmes** (4.3.8) : repas du soir peu mangé, **grignotage** tardif dans la chambre, coucher tardif et **manque de sommeil** (qui augmente la faim et l'envie d'aliments sucrés), absence de faim à 6 h 45, petit-déjeuner sauté, puis malaises et baisse d'attention en matinée. Les **déterminants** sont surtout environnementaux et sociaux : horaires de l'internat, offre du self le soir, provisions achetées le dimanche, et un rôle **social** fort du grignotage (« notre moment »), qu'il faut respecter.

3. Environnement : ouvrir le petit-déjeuner jusqu'à 7 h 40 ou proposer un petit-déjeuner « à emporter » (pain, fromage, fruit) à prendre avant 10 h ; associer les internes à la commission menus du soir. Éducation : un atelier « soirée entre internes » où ils préparent des collations conviviales et moins coûteuses (popcorn maison, compotes, fruits, pain d'épices). Partenariat : intervention de l'infirmière sur le sommeil et les écrans, sans discours moralisateur.

4. Part des internes qui prennent quelque chose avant 10 h (questionnaire avant et après) ; nombre de passages à l'infirmerie pour malaise le matin ; fréquentation du self le soir.

Cas guidé 5 – Les achats d'une épicerie solidaire (données fictives)

Une épicerie solidaire accueille **25 foyers** ; ils paient 10 à 30 % du prix habituel des produits. La responsable a analysé un mois d'achats : total **1 640 €** (prix payés). Répartition : fruits et légumes 197 € ; féculents 262 € ; viande, poisson, œufs et légumes secs 328 € ; produits laitiers 230 € ; produits sucrés et boissons sucrées 394 € ; matières grasses 82 € ; hygiène et divers 147 €.

- Les fruits et légumes frais arrivent irrégulièrement et s'abîment vite ; plusieurs familles sont hébergées à l'hôtel, avec une seule plaque électrique.
- Verbatims : « Les gâteaux, ça fait plaisir aux enfants, on ne peut pas tout leur refuser. » ; « Les lentilles, je ne sais pas les cuisiner. »

Questions – Cas guidé 5

1. Vérifiez le total, puis calculez la part de chaque poste et la dépense moyenne par foyer et par mois.

2. Comparez la part des fruits et légumes avec celle du budget de la famille présenté en 4.3.14 (28,6 %) et expliquez l'écart.

3. Proposez deux actions qui respectent la dignité des familles.

Corrigé – Cas guidé 5

1. Total : 197 + 262 + 328 + 230 + 394 + 82 + 147 = **1 640 €** ✓. Parts : fruits et légumes 197 / 1 640 × 100 = **12,0 %** ; féculents **16,0 %** ; viande, poisson, œufs et légumes secs **20,0 %** ; produits laitiers **14,0 %** ; produits sucrés et boissons sucrées **24,0 %** ; matières grasses **5,0 %** ; hygiène et divers **9,0 %**. Dépense moyenne : 1 640 / 25 = **65,60 €** par foyer et par mois.

2. Les fruits et légumes représentent 12,0 % des achats, contre 28,6 % dans le budget construit avec une famille, soit moins de la moitié. Explications : **offre** irrégulière et périssable (déterminant environnemental), **équipement** limité (une plaque, pas de four ni de réfrigérateur à l'hôtel), manque de **savoir-faire** (« je ne sais pas les cuisiner »), et rôle **affectif** des produits sucrés : faire plaisir aux enfants malgré la précarité (4.3.14). Ce n'est pas un manque de connaissances.

3. Un atelier « cuisine à une seule plaque » avec des légumes surgelés et des légumes secs en conserve (déjà cuits), avec dégustation et recettes à emporter ; un travail avec l'épicerie sur l'**offre** (surgelés nature, conserves de légumes, fruits à prix symbolique placés à l'entrée). On ne retire pas les produits sucrés des rayons et on ne commente pas les paniers individuels : les familles choisissent.

Cas guidé 6 – Une réunion de parents en protection maternelle et infantile (données fictives)

La puéricultrice d'un centre de PMI organise une réunion sur l'alimentation des enfants de 1 à 3 ans. Elle a

interrogé **30 parents** avant la réunion.

- « Je force mon enfant à finir son assiette » : 13 ; « je promets le dessert s'il mange ses légumes » : 17 ; « je prépare un autre plat quand il refuse » : 9 ; « j'ai commencé la diversification avant 4 mois » : 4.
- Verbatims : « Il ne mange rien, je suis épuisée. » ; « Chez sa grand-mère, il mange tout. »

Questions – Cas guidé 6

1. Calculez le pourcentage de parents concernés par chaque pratique.

2. Analysez ces pratiques avec le partage des responsabilités (Satter) et les styles parentaux.

3. Rédigez trois messages pour la réunion, positifs et sans jugement.

Corrigé – Cas guidé 6

1. Forcer à finir : 13 / 30 = **43,3 %** ; dessert en récompense : 17 / 30 = **56,7 %** ; autre plat préparé : 9 / 30 = **30,0 %** ; diversification avant 4 mois : 4 / 30 = **13,3 %**.

2. Forcer à finir et promettre le dessert relèvent d'un style **contrôlant** : le parent décide à la place de l'enfant de **combien** il mange, ce qui, selon le **partage des responsabilités** (4.3.9), revient à l'enfant ; la récompense par le dessert augmente l'attrait du dessert et diminue celui du légume (études de Birch, 4.3.9). Préparer un autre plat relève d'un style **permissif** : l'enfant décide du menu, ce qui revient au parent. La diversification avant 4 mois ne suit pas les repères actuels (entre 4 et 6 mois). La remarque sur la grand-mère montre que le **contexte** (calme, absence de pression, modèle des autres convives) compte beaucoup. Les parents épuisés ont surtout besoin d'être rassurés : la sélectivité est fréquente et souvent transitoire à cet âge.

3. « Vous choisissez quoi, quand et où ; votre enfant choisit combien : vous pouvez lui faire confiance. » ; « Un légume refusé aujourd'hui peut être accepté après plusieurs présentations : continuez à le proposer, sans forcer et sans récompense. » ; « Mangez avec lui, à table, sans écran : il apprend en vous regardant. »

4.4 Approfondissements

4.4.1 Le goût : un apprentissage

Les préférences innées sont limitées (attrait pour le sucré, l'umami et le salé ; rejet initial de l'amer et de l'acide). La plupart des goûts sont **appris** : dès la vie fœtale (les arômes du liquide amniotique), par l'allaitement (le lait maternel transmet des arômes de l'alimentation de la mère), puis par l'exposition répétée, l'imitation et le contexte émotionnel. Les **aversions conditionnées** (un aliment associé à une maladie digestive) peuvent durer toute la vie. L'éducation sensorielle (classes du goût, Semaine du goût) s'appuie sur cette plasticité.

Nous ne percevons pas tous les goûts de la même façon

Le goût au sens courant est en réalité la **flaveur** : l'ensemble des sensations perçues en bouche, qui associe les **saveurs** (perçues par la langue), les **arômes** (perçus par le nez, par voie rétronasale), la **texture**, la température et les sensations dites trigéminales (piquant du piment, fraîcheur de la menthe, pétillant). Cette perception varie d'une personne à l'autre, pour des raisons biologiques et pas seulement par « caprice ».

Composante	Organe et mécanisme	Ce qu'il faut savoir pour l'éducation
Saveurs (sucré, salé, acide, amer, umami)	Cellules des bourgeons du goût, sur la langue, le palais, le pharynx ; récepteurs spécifiques (environ vingt-cinq récepteurs différents de l'amer chez l'humain)	La « carte de la langue » (le sucré à la pointe, l'amer au fond) est une **idée fausse** : chaque zone perçoit toutes les saveurs

Composante	Organe et mécanisme	Ce qu'il faut savoir pour l'éducation
Arômes	Muqueuse olfactive, atteinte par l'arrière de la bouche quand on mâche et avale (rétro-olfaction)	La plus grande part de ce que l'on appelle « goût » vient de l'odorat : avec le nez pincé, on distingue mal une pomme d'une poire
Texture	Récepteurs du toucher dans la bouche	Une texture refusée (grumeaux, filandreux, gluant) est une cause fréquente de rejet chez l'enfant
Sensations trigéminales	Nerf trijumeau (piquant, frais, astringent)	Elles varient beaucoup selon l'habitude (tolérance au piment)

Définition – Goûteurs et non-goûteurs

La sensibilité à certaines molécules amères (la **PTC** et le **PROP**, proches de composés présents dans les choux, le brocoli, les endives) dépend en grande partie d'un gène (TAS2R38). On distingue des **non-goûteurs**, qui perçoivent peu ou pas cette amertume (environ un quart à un tiers des personnes d'origine européenne, beaucoup moins dans d'autres populations), des goûteurs moyens et des **super-goûteurs**, décrits par Linda Bartoshuk dans les années 1990, très sensibles à l'amer et souvent à l'intensité des saveurs en général.

Lien diététique – Ce que cela change en pratique

- Un enfant qui refuse les choux ou les endives n'est pas forcément « difficile » : il peut percevoir une amertume réelle, plus forte que celle que perçoit l'adulte. On propose des préparations qui atténuent l'amertume (gratin, purée mélangée, association avec un ingrédient doux), et on continue l'**exposition répétée** (chapitre 3, 3.4.1).
- Avec l'âge, l'**odorat** diminue souvent nettement après 60 à 70 ans ; des médicaments, le tabac, certaines maladies ou traitements (chimiothérapie) modifient aussi le goût. Une personne âgée qui trouve que « tout a le même goût » mange moins : on relève les plats avec des herbes, des épices douces, des sauces, en jouant sur les couleurs et les textures, plutôt qu'en ajoutant du sel ou du sucre (lien avec la dénutrition, 4.3.10).
- L'**habitude** déplace les seuils : une personne qui réduit progressivement le sel ou le sucre trouve, après quelques semaines, les produits habituels trop salés ou trop sucrés.

Calcul détaillé – Préparer une gamme de solutions sucrées pour un atelier « classement »

On veut faire classer quatre solutions de saccharose à 0, 10, 20 et 40 g par litre, à 12 participants, chacun goûtant 20 mL de chaque solution.

- Volume nécessaire par solution : 12 × 20 = **240 mL** ; on prépare **250 mL** de chaque.
- Sucre à peser : 0,250 × 0 = **0 g** ; 0,250 × 10 = **2,5 g** ; 0,250 × 20 = **5 g** ; 0,250 × 40 = **10 g**.
- Total de sucre : 0 + 2,5 + 5 + 10 = **17,5 g**, soit environ 3 à 4 morceaux de sucre de 5 g.
- Comparaison : un cola sucré contient 10 g de sucres pour 100 g (Ciqual 2025), soit environ **100 g par litre**, c'est-à-dire 100 / 40 = **2,5 fois** la solution la plus sucrée de l'atelier.

Interprétation : la solution à 40 g par litre paraît déjà très sucrée à la plupart des participants ; la comparaison avec le cola rend concret le niveau de sucre auquel on s'habitue, sans discours culpabilisant.

Exemple – L'expérience du nez pincé

En atelier, chaque participant goûte, les yeux fermés et le nez pincé, un petit morceau de pomme, puis de poire, puis d'oignon cru. Beaucoup ne savent pas les distinguer, ou trouvent seulement « un peu sucré ». Dès qu'ils relâchent le nez, l'arôme arrive et l'aliment est reconnu. L'expérience montre en deux minutes que l'odorat fait l'essentiel du goût, et explique pourquoi un rhume ou le vieillissement diminuent l'envie de

manger.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.25

Une animatrice d'EHPAD signale que les résidents « salent tout » et se plaignent que « les repas n'ont pas de goût ». a) Proposez deux explications liées à la perception. b) Proposez trois adaptations des plats qui ne passent pas par le sel. c) Pourquoi ne faut-il pas supprimer la salière sans en parler avec les résidents ?

Corrigé

a) Diminution de l'**odorat** avec l'âge (les arômes, qui font l'essentiel du goût, sont moins perçus) ; effet de certains **médicaments** ou d'une bouche sèche qui modifient la perception des saveurs ; on peut ajouter des plats peu relevés ou des textures monotones (mixé). **b)** Herbes fraîches et aromates (persil, ciboulette, ail, échalote), épices douces (cumin, curry doux, paprika), jus de citron ou vinaigre, sauces maison, contrastes de textures et de couleurs dans l'assiette. **c)** Pour une personne âgée, le plaisir de manger est un rempart contre la **dénutrition** ; supprimer le sel sans explication réduit l'appétit et la confiance ; la limitation du sel se discute avec le médecin selon la situation (insuffisance cardiaque, hypertension), et se fait progressivement.

4.4.2 Manger en pleine conscience et approches non restrictives

Des approches comme l'**alimentation intuitive** (Tribole et Resch, 1995) ou l'approche du **GROS** (Groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids) proposent de **réhabiliter les sensations** alimentaires (faim, rassasiement, plaisir) plutôt que de prescrire des régimes. Le guide du BTS cite ces approches (approche bio-psycho-sensorielle, thérapie d'acceptation et d'engagement, pleine conscience) parmi les ressources de la prise en charge. En santé publique, elles inspirent des ateliers de **dégustation en pleine conscience** (manger lentement, décrire, repérer le rassasiement).

4.4.3 La dimension sociale du repas et la santé

Le repas partagé est associé à une meilleure qualité de l'alimentation chez l'enfant (repas familiaux réguliers) et à de meilleurs apports chez la personne âgée (facilitation sociale). À l'inverse, l'**isolement** est un facteur de risque de dénutrition. Les actions de santé publique peuvent donc viser le **contexte** du repas (convivialité, horaires, lieu), et pas seulement son contenu.

4.4.4 Le gaspillage alimentaire

En France, en 2023, les déchets alimentaires représentent **9,7 millions de tonnes** sur toute la chaîne, dont **3,8 millions de tonnes** de parties comestibles, c'est-à-dire de gaspillage, soit environ 55 kg par habitant ; les ménages, à domicile, en produisent la plus grande part (SDES, 30 octobre 2025 ; méthode européenne, non comparable à l'ancienne estimation de l'ADEME de 2016, environ 10 millions de tonnes sur un champ plus large). La loi **Garot** (2016) a interdit la destruction d'invendus consommables par les grandes surfaces et organisé le don aux associations ; la loi **EGalim** (2018) et la loi **AGEC** (2020) ont étendu les obligations (diagnostic anti-gaspillage en restauration collective, don des excédents). En éducation, la lutte contre le gaspillage relie nutrition, budget et environnement : bien conserver, comprendre les dates (DLC « à consommer jusqu'au » ; DDM « à consommer de préférence avant »), cuisiner les restes, adapter les portions.

4.4.5 Alimentation et ultra-transformation : comprendre le débat

La classification **NOVA** (Monteiro, Brésil) classe les aliments selon leur degré de transformation : 1. bruts ou peu transformés ; 2. ingrédients culinaires (huile, sucre, sel) ; 3. aliments transformés (conserves, fromages, pain artisanal) ; 4. **ultra-transformés** (formulations industrielles contenant des ingrédients peu utilisés en cuisine : arômes, émulsifiants, édulcorants, protéines isolées). Des études de cohorte, dont NutriNet-Santé, associent une

consommation élevée d'aliments ultra-transformés à un risque accru d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de diabète et de mortalité, mais la causalité et les mécanismes restent discutés. Les repères de 2019 recommandent de **privilégier les aliments peu transformés** et de **limiter** les aliments ultra-transformés, en complément du Nutri-Score (qui mesure la qualité nutritionnelle, pas le degré de transformation).

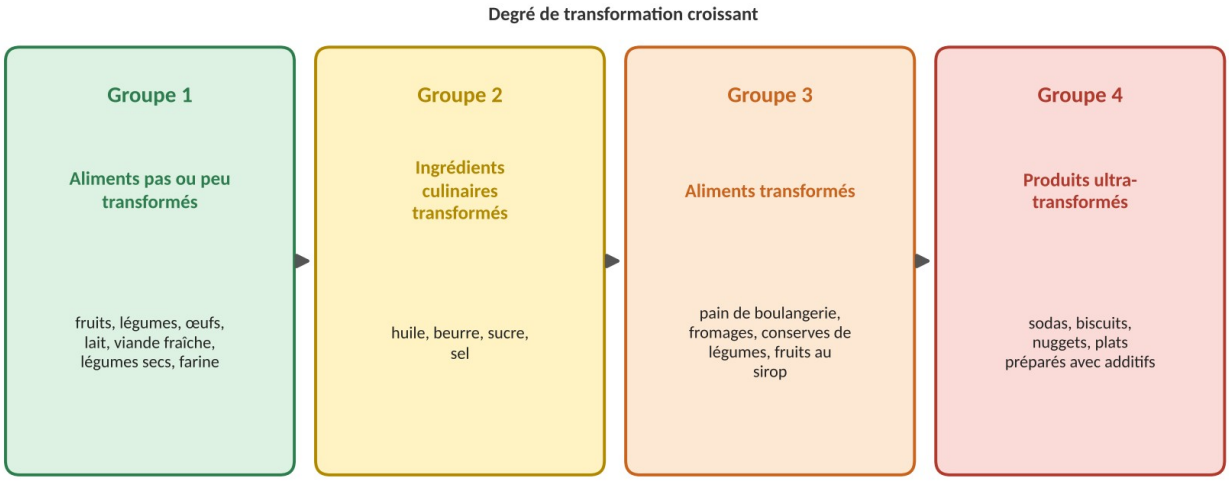


Figure 4.8 bis – La classification NOVA des aliments selon leur degré de transformation

Comprendre le schéma – Figure 4.8 bis

1. La classification NOVA, proposée par l'équipe de Carlos Monteiro (université de São Paulo), range les aliments en **quatre groupes**, de gauche à droite selon le degré de transformation.
2. **Groupe 1** : aliments pas ou peu transformés (fruits, légumes, œufs, lait, viande fraîche, légumes secs, farine).
3. **Groupe 2** : ingrédients culinaires transformés, utilisés pour cuisiner (huile, beurre, sucre, sel).
4. **Groupe 3** : aliments transformés, obtenus en ajoutant des ingrédients du groupe 2 à des aliments du groupe 1 (pain de boulangerie, fromages, conserves de légumes, fruits au sirop).
5. **Groupe 4** : produits ultra-transformés, formulations industrielles contenant des substances peu ou pas utilisées en cuisine (arômes, émulsifiants, édulcorants, protéines isolées).
6. La classification porte sur la **transformation**, pas sur la composition nutritionnelle : elle complète le Nutri-Score, elle ne le remplace pas.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.26

Classez dans les groupes NOVA : a) une compote de pommes « pomme, sucre » ; b) un yaourt nature ; c) une boisson aromatisée « zéro sucre » avec édulcorants ; d) un pain de mie avec émulsifiants ; e) des flocons d'avoine ; f) du beurre. Indiquez ensuite le produit de remplacement simple que vous proposeriez pour c) et d).

Corrigé

a) Groupe 3 (fruit et sucre ajouté). **b)** Groupe 1 (lait fermenté, sans autre ingrédient), parfois classé en groupe 3 selon les auteurs. **c)** Groupe 4. **d)** Groupe 4. **e)** Groupe 1. **f)** Groupe 2. Remplacements : pour c), de l'eau, plate ou gazeuse, avec quelques rondelles d'agrume ; pour d), du pain de boulangerie (groupe 3), en tranches congelées pour le garder.

4.4.6 Nouveaux aliments et acceptabilité : insectes et substituts végétaux

La transition vers une alimentation plus durable (4.3.12) passe par des aliments nouveaux ou peu familiers : insectes, produits à base de protéines végétales texturées, et demain peut-être d'autres sources. Leur succès ne dépend pas seulement de leur composition : il dépend de **comportements** étudiés dans ce chapitre (néophobie, dégoût, normes culturelles, prix, goût).

Définition – Le dégoût

Le **dégoût** est une émotion de rejet face à un aliment perçu comme contaminant ou offensant, souvent en raison de son **origine** ou de son idée plutôt que de son goût (Rozin et Fallon, 1987). Il se distingue du simple « je n'aime pas » : une personne dégoûtée refuse même de goûter, ou rejette un plat qui a seulement touché l'aliment. En France, les insectes provoquent souvent du dégoût, alors qu'environ deux milliards de personnes dans le monde en consomment de façon traditionnelle (FAO, 2013).

Aliment	Cadre et situation	Freins observés	Leviers
Insectes	« Nouveaux aliments » selon le règlement européen 2015/2283 : autorisation nécessaire ; autorisés notamment le ténébrion meunier séché (2021), le criquet migrateur (2021), le grillon domestique (2022) et le petit ténébrion (2023) ; étiquetage d'un risque d'allergie croisée avec les crustacés et les acariens	Dégoût, absence de tradition, prix élevé	Formes « invisibles » (farine dans des biscuits) ; dégustation volontaire, jamais imposée ; curiosité chez les enfants
Substituts végétaux (galettes, émincés, haché végétal)	Produits transformés à base de soja, de blé ou de pois ; les décrets français de 2022 et 2024 ont été annulés après l'arrêt de la Cour de justice de l'UE (4 octobre 2024) ; un règlement européen réservant « steak », « bacon » ou « foie » aux produits carnés (mais pas « burger » ni « saucisse ») a été voté par le Parlement européen le 16 juin 2026 et attendait l'accord formel des États	Goût et texture jugés décevants par certains, prix, image de produit ultra-transformé	Utilisation dans des recettes familières (bolognaise, burgers) ; comparaison des étiquettes
Légumineuses « brutes »	Aliment traditionnel, recommandé au moins deux fois par semaine (Santé publique France, 2019)	Temps de cuisson, inconfort digestif, image « vieillotte »	Conserves déjà cuites, recettes du monde (dahl, houmous, chili)

Calcul détaillé – Une galette végétale, un steak haché et des lentilles (Ciqual 2025, pour 100 g)

- **Galette blé et soja végane** : 215 kcal ; 16 g de protéines ; 11 g de lipides ; 6,0 g de fibres ; **1,3 g de sel** ; 3,3 mg de fer.
- **Steak haché à 15 % de matières grasses, cru** : 215 kcal ; 20,2 g de protéines ; 14,8 g de lipides ; 0 g de fibres ; 0,1 g de sel (avant salage) ; 2,64 mg de fer (en partie héminique, mieux absorbé).
- **Lentilles vertes cuites** : 125 kcal ; 10,1 g de protéines ; 0,58 g de lipides ; 8,45 g de fibres ; 0,015 g de sel ; 2,45 mg de fer. Pour une portion de 150 g : 150 × 10,1 / 100 = **15,2 g** de protéines et 150 × 8,45 / 100 = **12,7 g** de fibres.

- Sel de la galette : 1,3 / 0,1 = **13 fois** plus que la viande crue ; une galette de 100 g apporte 1,3 / 5 × 100 = **26 %** de la limite de 5 g de sel par jour conseillée par l'OMS.

Interprétation : la galette végétale apporte des fibres et des protéines, mais elle est salée et transformée ; elle peut aider une famille à réduire la viande, sans être « meilleure » par nature. Les légumineuses cuisinées restent l'option la plus intéressante pour la santé et le budget (4.3.14).

À vous de jouer – Exercice d'application 4.27

Un animateur de centre de loisirs veut organiser une « dégustation d'insectes » pour des enfants de 8 à 10 ans, en disant aux parents que « c'est l'aliment du futur ». a) Quelles réactions des enfants faut-il prévoir ? b) Quelles précautions sont indispensables ? c) Comment présenter l'activité de façon honnête ?

Corrigé

a) Curiosité chez certains, **dégoût** et refus chez d'autres, effet de groupe (moqueries ou défis). **b)** Informer les parents et recueillir leur accord ; vérifier les **allergies** (crustacés, acariens, risque d'allergie croisée) ; utiliser des produits autorisés et étiquetés ; laisser chaque enfant libre de goûter ou non, sans pression ni défi. **c)** Présenter une découverte culturelle (pays où les insectes sont consommés, intérêt environnemental discuté), sans promettre que ce sera « l'aliment du futur » : la question est encore débattue et dépendra des goûts, des prix et des choix collectifs.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.4 – Approfondissements

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelles sont les préférences gustatives innées du nouveau-né ?
2. Pourquoi un enfant non-goûteur et un enfant super-goûteur ne réagissent-ils pas de la même façon aux endives ?
3. Citez deux approches non restrictives de l'alimentation.
4. Pourquoi le repas partagé est-il un enjeu de santé chez la personne âgée ?
5. Distinguez DLC et DDM.
6. Que classe la classification NOVA, et quelle est sa principale limite ?
7. Qu'est-ce que le dégoût, et en quoi diffère-t-il du simple « je n'aime pas » ?
8. Pourquoi une galette végétale n'est-elle pas forcément « meilleure » qu'un plat de lentilles ?

Corrigé – Point d'étape 4.4

1. Attrait pour le sucré, l'umami et le salé ; rejet initial de l'amer et de l'acide.
2. Le super-goûteur perçoit beaucoup plus l'amertume de certaines molécules présentes dans les endives et les choux (sensibilité au PROP liée au gène TAS2R38) : son refus n'est pas un caprice.
3. L'alimentation intuitive, l'approche du GROS, la pleine conscience (au choix).
4. L'isolement est un facteur de risque de dénutrition ; manger avec d'autres augmente les apports (facilitation sociale) et le plaisir.
5. DLC : « à consommer jusqu'au », pour les denrées périssables, à ne pas dépasser ; DDM : « à consommer de préférence avant », le produit reste consommable après la date, avec une possible perte de qualité.
6. Le degré de transformation des aliments (4 groupes) ; elle ne tient pas compte de la composition nutritionnelle et la frontière entre groupes est parfois discutée.
7. Une émotion de rejet liée à l'origine ou à l'idée de l'aliment (Rozin et Fallon, 1987), qui fait refuser même de goûter.
8. Elle est transformée et salée (1,3 g de sel pour 100 g dans Ciqual 2025) ; les lentilles cuisinées apportent

plus de fibres, presque pas de sel, et coûtent moins cher.

4.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – La régulation neuro-hormonale en détail

L'hypothalamus (noyau arqué) contient deux populations de neurones : les neurones **NPY/AgRP** (orexigènes, stimulés par la ghréline) et les neurones **POMC/CART** (anorexigènes, stimulés par la leptine et l'insuline). La **leptine**, proportionnelle à la masse grasse, signale les réserves à long terme ; dans l'obésité, on observe une **résistance à la leptine**. Les analogues du **GLP-1** (sémaglutide), utilisés dans le traitement du diabète de type 2 et de l'obésité, agissent sur la satiété et la vidange gastrique ; leur diffusion récente modifie la prise en charge de l'obésité et pose de nouvelles questions nutritionnelles (perte de masse musculaire, accompagnement diététique).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Restriction cognitive : mesure et débats

La restriction cognitive se mesure par des questionnaires validés (*Three-Factor Eating Questionnaire* de Stunkard et Messick, 1985 : restriction, désinhibition, faim ; *Dutch Eating Behaviour Questionnaire*). Les travaux distinguent une restriction **rigide** (règles strictes, associée à la désinhibition et à la prise de poids) et une restriction **flexible** (ajustements souples, moins délétère). Ces nuances invitent à ne pas condamner toute attention portée à l'alimentation, mais à prévenir la rigidité.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le « mangeur pluriel » et l'individualisation

Les sociologues décrivent un mangeur **pluriel**, dont les pratiques varient selon les contextes (semaine/week-end, seul/en famille, travail/domicile), et une tension entre **individualisation** (choix personnels, régimes, préférences) et maintien du **repas commun** comme norme. En France, les enquêtes comparatives (Fischler et Masson, *Manger : Français, Européens et Américains face à l'alimentation*, 2008) montrent un attachement plus fort qu'ailleurs au repas partagé et au plaisir, considérés comme protecteurs.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La sélectivité alimentaire et l'ARFID

La **sélectivité alimentaire** (*picky eating*) est fréquente chez le jeune enfant et généralement transitoire. Elle se distingue du **trouble de restriction ou d'évitement de l'ingestion des aliments** (ARFID, DSM-5, 2013), qui associe un évitement important (sensoriel, peur d'avaler, manque d'intérêt) à des conséquences : perte de poids ou cassure de la courbe de croissance, carences, dépendance à des compléments, retentissement social. L'ARFID relève d'une prise en charge pluridisciplinaire ; en santé publique, on repère et on oriente.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Les habitudes : automatisme et environnement

En psychologie, une **habitude** est un comportement déclenché automatiquement par un **contexte** (lieu, heure, émotion), après de nombreuses répétitions (Wood et Neal, 2007). Une étude de Lally et coll. (2010) a montré que l'automatisme d'un nouveau comportement de santé s'installe en moyenne en **66 jours**, avec une grande variabilité (18 à 254 jours). Conséquences : associer le nouveau comportement à un contexte stable (« un fruit au goûter, chaque jour à 16 h 30 »), tolérer les oublis, et modifier l'environnement qui déclenche les anciennes habitudes.

Pour aller plus loin – niveau L3 – « Aimer » et « vouloir » : deux systèmes distincts

Les travaux de Kent Berridge (université du Michigan, depuis les années 1990) distinguent deux composantes de la récompense alimentaire. L'**appréciation** (*liking*) est le plaisir ressenti en mangeant ; elle dépend de petites zones du cerveau et des systèmes opioïdes et endocannabinoïdes. Le **désir** (*wanting*) est la motivation à obtenir l'aliment ; il dépend surtout de la **dopamine** et peut être déclenché par des indices de l'environnement (odeur, emballage, publicité, heure habituelle). Les deux sont en général liés, mais peuvent se dissocier : on peut « vouloir » intensément un aliment que l'on n'apprécie plus beaucoup une fois en bouche. Cette distinction éclaire l'**externalité** (4.3.3), le rôle des indices dans le grignotage, et le débat sur l'« addiction alimentaire » (4.3.3) : c'est le désir, plus que le plaisir, qui peut s'emballer. Pour l'éducation, elle invite à travailler sur l'environnement et les indices, et à réhabiliter le plaisir de la dégustation plutôt qu'à le combattre.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Définir un aliment « hyperpalatable » : les critères de Fazzino (2019)

Tera Fazzino et collaborateurs (revue *Obesity*, 2019) ont proposé une définition chiffrée des aliments **hyperpalatables**, dont les combinaisons de nutriments seraient particulièrement attirantes. Un aliment l'est s'il remplit au moins un critère : **gras et sodium** (lipides > 25 % de l'énergie et sodium ≥ 0,30 % du poids) ; **gras et sucres** (lipides > 20 % et sucres simples > 20 % de l'énergie) ; **glucides et sodium** (glucides > 40 % de l'énergie et sodium ≥ 0,20 % du poids). Les auteurs ont estimé qu'environ 62 % des aliments d'une base américaine remplissaient au moins un critère.

Application (Ciqual 2025, pour 100 g ; sodium = sel / 2,5) :

- Chips (532 kcal ; 32,7 g de lipides ; 1,35 g de sel) : lipides 32,7 × 9 / 532 × 100 = **55,3 %** de l'énergie ; sodium 1,35 / 2,5 = **0,54 g**, soit 0,54 % du poids : critère « gras et sodium » rempli.
- Petit beurre (450 kcal ; 13,3 g de lipides ; 22 g de sucres ; 73,4 g de glucides ; 1,04 g de sel) : lipides **26,6 %** ; sucres 22 × 4 / 450 × 100 = **19,6 %** ; glucides **65,2 %** ; sodium **0,42 %** : critères « gras et sodium » et « glucides et sodium » remplis ; le critère « gras et sucres » est manqué de peu.
- Céréales chocolatées pour petit-déjeuner (393 kcal ; 5,1 g de lipides ; 22,5 g de sucres ; 0,3 g de sel) : lipides **11,7 %**, sucres **22,9 %**, sodium **0,12 %** : aucun critère, bien qu'elles soient très sucrées.
- Lentilles vertes cuites : lipides **4,2 %**, sodium **0,006 %** : aucun critère.

Limites : les seuils ont été choisis à partir de la littérature et non à partir de la réponse réelle des mangeurs ; la définition ne prend en compte ni la texture, ni les arômes, ni la densité énergétique, ni le prix ; un même aliment peut changer de catégorie selon la recette. Elle est utile pour décrire une offre alimentaire (part des produits hyperpalatables dans un distributeur), pas pour juger un mangeur.

Pour aller plus loin – niveau L3 – L'effet de la taille des portions

Dans une étude de laboratoire, Barbara Rolls et collaborateurs (2002) ont servi à des adultes, au déjeuner, un plat de macaronis au fromage en portions de 500, 625, 750 ou 1 000 g, sur quatre jours différents. Avec la plus grande portion, les participants ont consommé environ **30 % d'énergie en plus** qu'avec la plus petite, sans se déclarer plus rassasiés, et sans compenser ensuite. L'effet s'observe chez les personnes de poids normal comme en surpoids, chez l'enfant dès 5 ans environ, et pour de nombreux aliments. Exemple de calcul (données fictives) : une personne qui mange 500 kcal de ce plat avec la petite portion en mangerait environ 500 × 1,30 = **650 kcal** avec la grande. Ce résultat appuie les actions sur l'**environnement** (taille des assiettes et des contenants, portions servies en restauration collective, emballages individuels) plutôt que les seuls conseils de « volonté », et rejoint la notion d'**externalité** (4.3.3).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Décrire des profils alimentaires

En épidémiologie nutritionnelle, on ne s'intéresse pas seulement aux aliments pris un par un : on recherche des **profils** (ou *dietary patterns*) qui regroupent les aliments consommés ensemble. Deux familles de méthodes existent (Hu, 2002) : des méthodes **a priori**, qui comparent l'alimentation à un score construit à

partir des recommandations (par exemple le score d'adéquation au PNNS), et des méthodes **a posteriori**, qui font émerger les profils des données (analyse en composantes principales, classification). Les études retrouvent souvent un profil « prudent » (fruits, légumes, légumineuses, poisson, céréales complètes) et un profil « occidental » (viandes rouges et transformées, produits raffinés, boissons sucrées, desserts). Exemple fictif : une classification des réponses de 400 adultes fait apparaître trois groupes de 152, 128 et 120 personnes, soit **38 %**, **32 %** et **30 %**. **Limites** : les profils dépendent de la population étudiée, des aliments retenus et des choix de l'analyste (nombre de groupes, noms donnés aux profils) ; un profil décrit une association, pas une cause. Pour le diététicien en santé publique, ces profils aident à cibler une action (par exemple un groupe de jeunes adultes au profil « occidental » et au budget serré).

4.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Restriction et consultation

Une patiente consulte pour « perdre 5 kg avant l'été » et suit déjà des règles strictes. Le diététicien repère la **restriction cognitive** et l'insatisfaction corporelle, évite de prescrire un régime, travaille les sensations alimentaires et oriente si des signes de TCA apparaissent.

Situation bc2 – Menus et pratiques des convives

En restauration collective, le diététicien intègre les pratiques des convives : menu végétarien hebdomadaire (EGalim), alternatives sans porc, repas adaptés pendant le Ramadan dans un foyer de jeunes travailleurs, en garantissant l'équilibre nutritionnel.

Situation bc3 – Atelier « faim et envie » pour des adultes

Dans un centre social, un atelier de dégustation en pleine conscience permet de repérer la faim, le rassasiement et le plaisir ; il prévient la restriction et l'alimentation émotionnelle, sans parler de poids.

Situation bc3 – Accompagner les jeunes végétariens

Un lycée constate une hausse des demandes de repas végétariens ; le diététicien conçoit une action d'information sur l'équilibre végétarien (fer, B12 pour les végétaliens) et un atelier de recettes à base de légumineuses, en respectant les choix des élèves.

Situation bc2 – Collation matinale à l'école

Une école distribue une collation à 10 h (jus et biscuits). Le diététicien rappelle l'avis de l'AFSSA (2004), propose de déplacer l'effort sur le petit-déjeuner (petits-déjeuners pédagogiques en classe) et de réserver une collation (fruit, pain, produit laitier) aux enfants n'ayant pas déjeuné.

Situation bc3 – Alimentation durable en centre social

Un centre social veut des « ateliers durables ». Le diététicien conçoit des recettes de saison, à base de légumes secs, avec un calcul du coût et de l'empreinte carbone par portion, et un module anti-gaspillage (dates, restes), sans culpabiliser les familles.

4.6.1 Préparer l'oral : défendre une analyse de comportement alimentaire

À l'épreuve, le jury demande souvent de **justifier** un choix : pourquoi cette action plutôt qu'une autre, pourquoi ne pas avoir proposé de régime, pourquoi parler de plaisir. Les réponses s'appuient sur les notions du chapitre et sur des sources datées.

À l'oral – Trois questions fréquentes du jury et des éléments de réponse

- **« Pourquoi n'avez-vous pas parlé de poids dans votre atelier ? »** Parce que les messages centrés sur le poids favorisent la restriction cognitive (Herman et Polivy, 1975), la stigmatisation et, chez les jeunes, les TCA ; l'objectif de santé est atteint par le plaisir, les sensations, la régularité et l'environnement.
- **« Votre public dit ne pas avoir le temps de cuisiner : que proposez-vous ? »** Partir de la contrainte (déterminant environnemental) : cuisine en avance, recettes de moins de 20 minutes, produits bruts surgelés ou en conserve ; agir aussi sur l'environnement (restauration collective, offre près du travail).
- **« Comment savez-vous que votre recette sera acceptée ? »** Par une dégustation avec une échelle hédonique et le calcul d'un taux d'acceptation (notes 4 et 5), en tenant compte des pratiques recueillies (fiche O4.1).

Point d'étape – Vrai ou faux ? Quinze affirmations à justifier

1. Le rassasiement se produit après le repas et détermine le délai jusqu'au repas suivant.
2. La restriction cognitive consiste à manger selon des règles plutôt que selon ses sensations.
3. Selon Satter, l'enfant décide de ce qu'il mange.
4. La néophobie est maximale entre 2 et 6 ans.
5. Une collation à 10 h est recommandée pour tous les enfants de l'école élémentaire.
6. Un végétalien doit prendre un supplément de vitamine B12.
7. Le Nutri-Score mesure le degré de transformation d'un aliment.
8. Le diététicien de santé publique peut utiliser le questionnaire SCOFF en atelier collectif pour dépister les TCA.
9. Les aliments denses en énergie apportent les calories les moins chères.
10. La laïcité interdit à une cantine publique de proposer un plat sans porc.
11. Retarder l'introduction de l'œuf protège le bébé des allergies.
12. Le syncrétisme culinaire est la combinaison d'éléments de cultures culinaires différentes.
13. Une portion plus grande fait manger davantage sans augmenter beaucoup la satiété.
14. Les distributeurs automatiques payants d'aliments sont autorisés dans les collèges.
15. Le dîner doit apporter au moins 40 % de l'énergie de la journée.

Corrigé – Vrai ou faux

1. Faux : le rassasiement se produit **pendant** le repas et conduit à l'arrêter ; c'est la satiété qui suit le repas. 2. Vrai (Herman et Polivy, 1975). 3. Faux : le parent décide quoi, quand et où ; l'enfant décide s'il mange et combien. 4. Vrai. 5. Faux : elle n'est pas recommandée pour les enfants qui ont pris un petit-déjeuner (AFSSA, 2004). 6. Vrai : la vitamine B12 n'est présente en quantité utile que dans les produits animaux. 7. Faux : il mesure la qualité nutritionnelle ; c'est la classification NOVA qui décrit la transformation. 8. Faux : c'est un outil de repérage individuel réservé aux professionnels de santé dans une relation de soin. 9. Vrai (Drewnowski et Darmon, 2005). 10. Faux : la laïcité n'oblige pas à proposer des menus confessionnels, mais ne l'interdit pas ; beaucoup de communes proposent un plat de substitution. 11. Faux : les allergènes s'introduisent sans retard entre 4 et 6 mois (HCSP, 2020 ; Santé publique France, 2021). 12. Vrai. 13. Vrai (travaux de Barbara Rolls). 14. Faux : ils sont interdits dans les établissements scolaires depuis 2005 (loi du 9 août 2004). 15. Faux : la fourchette usuelle est de 25 à 30 %, et ce n'est pas une norme stricte.

4.6.2 Préparer l'atelier culinaire : lire le contexte imposé avec les notions du chapitre

Au temps 2 de l'épreuve E5, vous animez un **atelier culinaire dans un contexte imposé**. Le jury observe si vos choix (recette, organisation, messages) sont **adaptés au public**. Les notions de ce chapitre servent à lire le contexte : qui sont les participants, ce qu'ils mangent, ce qui compte pour eux, ce qui les freine. La conception d'un atelier interculturel est présentée au chapitre 3 ; on se concentre ici sur l'**analyse des comportements** qui justifie les choix.

Méthode pas à pas – Six questions pour lire un contexte imposé

1. Quel âge et quel stade ? Âge, autonomie, développement (4.3.9, 4.3.10) : un enfant de 4 ans ne manipule pas un couteau ; un adolescent cherche l'autonomie et l'image de soi.

2. Quels rôles de l'acte alimentaire comptent pour ce public ? Plaisir, convivialité, identité, santé (4.3.1) : pour des adolescents, partager et « faire comme les autres » ; pour une personne âgée isolée, le lien social.

3. Quelles pratiques ? Religieuses, culturelles, végétariennes, allergies (4.3.6, 4.3.15) : à vérifier dans le sujet ou à prévoir sous forme de variantes.

4. Quels déterminants pèsent le plus ? Budget, temps, équipement, compétences culinaires (4.3.4) : la recette doit pouvoir être refaite chez soi avec le matériel disponible.

5. Quelles régulations ou dérégulations repérer ? Grignotage, repas sautés, restriction (4.3.3, 4.3.8) : ils orientent le message (par exemple la collation prévue plutôt que le grignotage).

6. Comment saurai-je que l'atelier a plu ? Dégustation, échelle hédonique, question ouverte en fin d'atelier (4.3.16).

Exemple – Un contexte imposé analysé

Contexte : atelier de 2 heures pour 8 adolescents de 14 à 16 ans hébergés dans un foyer de l'Aide sociale à l'enfance ; budget de 25 € ; cuisine équipée d'un four ; les éducateurs signalent des repas sautés, beaucoup de commandes de pizzas et de kebabs le week-end, et deux jeunes qui ne mangent pas de porc.

Question	Ce que l'on repère	Décision
Âge, stade	Adolescents qui veulent de l'autonomie	Les jeunes choisissent leurs garnitures et réalisent tout eux-mêmes
Rôles	Plaisir, partage, identité (« manger comme les copains »)	Une recette qu'ils connaissent et aiment : la pizza
Pratiques	Deux jeunes ne mangent pas de porc	Garnitures sans porc pour tous (thon, légumes, mozzarella), pas de produit à part qui stigmatise
Déterminants	Faible budget, envie de rapidité, livraisons	Pâte rapide sans repos long, montrer que c'est moins cher qu'une livraison
Dérégulations	Repas sautés, commandes le week-end	Message : « une pizza maison en 30 minutes, c'est un vrai repas » ; pas de discours sur le poids
Évaluation	Plaisir et envie de refaire	Échelle hédonique en smileys et question « Que referais-tu chez toi ? »

Calcul détaillé – Le coût de l'atelier (prix fictifs, octobre 2026)

Pizza maison et salade de fruits pour 8 : farine 500 g (0,48 €), levure (0,30 €), huile 3 cL (0,07 €), coulis de tomate 500 g (1,20 €), mozzarella 250 g (1,90 €), légumes (poivrons, champignons, oignon : 3,10 €), 2 boîtes

de thon (3,00 €), fruits 1 kg (2,40 €), 8 yaourts nature (1,90 €).

- Total : 0,48 + 0,30 + 0,07 + 1,20 + 1,90 + 3,10 + 3,00 + 2,40 + 1,90 = **14,35 €**.
- Par participant : 14,35 / 8 = **1,79 €**.
- Reste sur le budget : 25 − 14,35 = **10,65 €**, qui peut servir à acheter des boîtes pour que chaque jeune emporte une part, ou des épices pour le foyer.

Interprétation : une pizza livrée coûte couramment entre 10 et 15 € : le repas complet de l'atelier revient à moins de 2 € par jeune. Cet écart est un argument concret et non culpabilisant, qui parle aux adolescents.

À l'oral – Justifier ses choix en une minute

« J'ai choisi la pizza parce que c'est un plat que les jeunes aiment et commandent souvent : partir de leurs pratiques favorise leur participation et l'envie de refaire. Les garnitures sont sans porc pour que tout le monde mange la même chose, sans mettre personne à part. Les jeunes réalisent tout eux-mêmes, car à cet âge l'autonomie compte. Mon message porte sur le plaisir, la rapidité et le coût, pas sur le poids, pour éviter de favoriser la restriction. J'évalue l'atelier par une échelle hédonique et une question sur ce qu'ils referaient chez eux. »

À vous de jouer – Exercice d'application 4.28

Contexte imposé : atelier de 2 heures pour 6 résidents d'une résidence autonomie (78 à 90 ans), dont deux portent un appareil dentaire et une personne a perdu l'appétit depuis son veuvage ; budget de 18 € ; cuisine avec plaques et four. a) Repérez, pour au moins quatre des six questions de la méthode, ce qui compte dans ce contexte. b) Proposez une recette et justifiez-la. c) Calculez le budget disponible par participant.

Corrigé

a) Âge : personnes âgées, risque de **dénutrition**, baisse du goût et de l'odorat (4.3.10). Rôles : **lien social** et plaisir avant tout (repas partagé contre l'isolement). Déterminants : appareils dentaires (textures tendres), habitudes culinaires anciennes, petit budget. Dérégulation : perte d'appétit liée au deuil (prises alimentaires réduites). Évaluation : plaisir, quantités mangées, envie de revenir. **b)** Un parmentier de poisson enrichi (purée au lait et au fromage râpé, poisson émietté), suivi d'une compote maison : texture tendre, recette connue, enrichi en protéines, parfumé (muscade, persil) ; préparé ensemble et mangé à table ensemble. **c)** 18 / 6 = **3,00 €** par participant.

4.6.3 Dix questions d'entretien pour s'entraîner

À l'entretien de l'épreuve E5, le jury part de votre dossier ou de votre atelier pour vérifier que vous **maîtrisez les notions** et que vous savez les **relier à une situation**. Entraînez-vous à répondre à voix haute en 1 minute à chaque question, puis comparez avec les éléments de réponse.

À l'oral – Dix questions et les éléments attendus

1. « Quelle différence faites-vous entre rassasiement et satiété ? » Le rassasiement met fin au repas, pendant la prise ; la satiété est l'absence de faim après le repas, qui détermine le délai jusqu'au repas suivant (4.3.3). Exemple : une boisson sucrée rassasie peu.

2. « Qu'est-ce que la restriction cognitive, et pourquoi en parler dans une action collective ? » Un contrôle mental de l'alimentation qui ne tient plus compte des sensations, avec un cycle de désinhibition et de culpabilité (Herman et Polivy, 1975) ; une action qui prescrit des interdits peut l'aggraver.

3. « Citez trois déterminants de l'alimentation de votre public et dites sur lequel votre action agit. » Un déterminant individuel, un social, un environnemental (4.3.4), puis préciser le niveau du modèle socio-

écologique visé par l'action.

4. « Comment avez-vous pris en compte les pratiques religieuses ? » On a **demandé** aux participants, sans supposer ; recette de base acceptable par tous, variantes à part, vérification des ingrédients cachés, calendrier (4.3.15).

5. « Pourquoi ne pas avoir donné de liste d'aliments interdits ? » Parce que l'interdit augmente l'attrait (études de Fisher et Birch) et la restriction ; on préfère l'ajout, le remplacement et le plaisir.

6. « Comment savez-vous que votre recette a plu ? » Échelle hédonique, calcul d'un taux d'acceptation, remarques recueillies, quantité de restes (4.3.11, 4.3.16).

7. « Un parent vous dit que son enfant refuse tous les légumes. Que lui répondez-vous ? » La néophobie est normale entre 2 et 10 ans ; exposition répétée sans pression, modèle de l'adulte, partage des responsabilités (4.3.9) ; orientation si la sélectivité s'accompagne de perte de poids.

8. « Qu'est-ce qu'une alimentation durable ? » Une alimentation qui protège la santé et l'environnement, accessible, culturellement acceptable et économiquement juste (FAO, 2010) ; les quatre dimensions vont ensemble (4.3.12).

9. « Quelle est la limite de votre rôle face à une personne qui présente peut-être un TCA ? » Le diététicien ne diagnostique pas en action collective ; il repère, écoute et oriente vers le médecin, avec discrétion (4.3.13).

10. « Vos chiffres viennent d'où ? » Citer la source, l'année et la méthode (Ciqual 2025, enquête Insee, avis ANSES, données recueillies auprès du public), et préciser quand une donnée est fictive ou ancienne.

Méthode pas à pas – Construire une réponse orale en trois temps

1. Définir la notion en une phrase, avec le mot exact.

2. Illustrer par un élément de votre stage ou de votre atelier (un chiffre, une phrase d'un participant, une décision).

3. Justifier : relier la notion au choix que vous avez fait, et citer une source datée si possible.

Exemple : « La néophobie est la peur de goûter un aliment nouveau. Au relais petite enfance, plusieurs parents nous ont dit que leur enfant refusait les légumes verts. C'est pour cela que nous avons proposé des dégustations répétées sans obligation, comme le recommandent les études sur l'exposition répétée. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.6 – Préparer l'épreuve

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six questions pour lire un contexte imposé d'atelier culinaire.
2. Quels sont les trois temps d'une réponse orale bien construite ?
3. Pourquoi faut-il préciser qu'une donnée est fictive ?
4. Dans le contexte du foyer de l'ASE (4.6.2), pourquoi les garnitures sont-elles sans porc pour tous ?

Corrigé – Point d'étape 4.6

1. Quel âge et quel stade ? Quels rôles de l'acte alimentaire ? Quelles pratiques ? Quels déterminants ? Quelles régulations ou dérégulations ? Comment évaluer ?
2. Définir, illustrer, justifier.
3. Par honnêteté scientifique : le jury doit pouvoir distinguer une donnée réelle et sourcée d'un exemple construit pour l'exercice.
4. Pour que tous les jeunes mangent le même plat, sans mettre à part ceux qui ne mangent pas de porc.

4.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Comportement et régulation

- **Rôles de l'acte alimentaire** : biologique, hédonique, psychologique, social, culturel et identitaire, économique.
- **Comportement alimentaire** : ensemble des conduites (choix, prises, rythmes, quantités, contexte) ; **besoin** (physiologique) ≠ **envie** ; **oralité** ; **pulsion**.
- **Faim** (avant, ghréline) → **rassasiement** (pendant, CCK, distension, rassasiement sensoriel spécifique) → **satiété** (après, GLP-1, PYY, insuline, leptine).
- Régulation **homéostatique** (hypothalamus) et **hédonique** (récompense, dopamine), influencée par les facteurs **cognitifs** et **environnementaux**.
- Dérégulations : **restriction cognitive** (Herman et Polivy, 1975 ; cercle vicieux), alimentation **émotionnelle**, **externalité**, grignotage, compulsions ; **TCA** : repérer et orienter (BC1).

À retenir – Pratiques

- Modèle français : 3 repas, à table, en commun ; part de l'alimentation dans la consommation : 35 % (1960) → 20 % (2014) ; hausse du hors-foyer, du snacking, des plats préparés.
- **Syncrétisme culinaire** : combinaison de cultures culinaires.
- 2020 : **2 %** de végétariens, pescétariens et végétaliens ; **24 %** de flexitariens (Ifop pour FranceAgriMer).
- Végétalisme : **supplémentation en vitamine B12 obligatoire** ; vigilance sur fer, calcium, iode, zinc, oméga-3.
- Accompagner : comprendre, respecter, partir de l'existant, préserver le plaisir, sécuriser, orienter.

À retenir – Compléments : rythmes, enfance, mesure, durabilité

- **Rythmes** : repas, collation (prévue), grignotage (sans faim) ; répartition indicative : petit-déjeuner 20-25 %, déjeuner 35-40 %, goûter 10-15 %, dîner 25-30 % ; régularité ; chrononutrition.
- **Enfant** : diversification entre 4 et 6 mois ; néophobie 2-6 ans ; 8 à 15 expositions ; partage des responsabilités (Satter) : le parent décide quoi, quand, où ; l'enfant si et combien.
- **Âges de la vie** : adolescence (petit-déjeuner, boissons, TCA), grossesse, personnes âgées (dénutrition) ; charge mentale alimentaire.
- **Mesure** : rappel de 24 h, carnet, fréquence, observation, pesée des restes.
- **Durabilité** : définition FAO (2010) ; EAT-Lancet (2019 ; mise à jour 2025) : environ 14 g de viande rouge par jour ; bœuf ≈ 50 fois l'empreinte des lentilles par portion ; gaspillage ≈ 3,8 millions de tonnes de parties comestibles en 2023 (SDES, 2025) ; NOVA et ultra-transformation.

4.8 Entraînement

4.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Le rassasiement :

a) survient pendant le repas **b)** conduit à l'arrêt de la prise alimentaire **c)** correspond à l'absence de faim entre deux repas **d)** est influencé par la distension gastrique

QCM 2 – La ghréline est :

a) une hormone orexigène sécrétée par l'estomac **b)** une hormone sécrétée par le tissu adipeux **c)** augmentée avant les repas **d)** une hormone de satiété

QCM 3 – La leptine :

a) est sécrétée par le tissu adipeux **b)** informe sur les réserves énergétiques à long terme **c)** stimule la faim **d)** fait l'objet d'une résistance dans l'obésité

QCM 4 – La restriction cognitive :

a) consiste à manger selon ses sensations **b)** remplace les sensations par des règles mentales **c)** peut favoriser des « craquages »

d) a été décrite par Herman et Polivy

QCM 5 – L'externalité désigne le fait de :

a) manger en réponse à des signaux extérieurs **b)** manger seulement hors du domicile **c)** écouter ses signaux de faim **d)** manger en réponse à la portion servie

QCM 6 – Le rassasiement sensoriel spécifique explique :

a) qu'on ait encore de la place pour le dessert **b)** que le plaisir diminue pour un aliment consommé **c)** l'anorexie mentale **d)** l'intérêt de la variété

QCM 7 – En 2020, la part des Français se déclarant flexitariens est d'environ :

a) 2 % **b)** 8 % **c)** 24 % **d)** 50 %

QCM 8 – Chez une personne végétalienne, il est indispensable de supplémenter en :

a) vitamine C **b)** vitamine B12 **c)** sodium **d)** glucides

QCM 9 – Le syncrétisme culinaire est :

a) la combinaison d'éléments de cultures culinaires différentes **b)** un régime d'exclusion **c)** un trouble du comportement alimentaire **d)** un résultat de la mondialisation et des migrations

QCM 10 – Face à un participant d'atelier présentant des signes d'anorexie, le diététicien :

a) établit le diagnostic **b)** propose un régime hypercalorique **c)** en parle avec discrétion et oriente vers un professionnel **d)** l'expose devant le groupe pour l'aider

QCM 11 – Les préférences gustatives innées concernent :

a) le sucré **b)** l'amer (attirance) **c)** le salé et l'umami **d)** les légumes verts

QCM 12 – La part de l'alimentation dans la consommation des ménages est passée de :

a) 35 % à 20 % entre 1960 et 2014 **b)** 10 % à 30 % **c)** 50 % à 45 % **d)** elle est restée stable

QCM 13 – Un environnement obésogène se caractérise par :

a) des portions de grande taille **b)** une offre abondante d'aliments très palatables **c)** des déplacements actifs **d)** un marketing omniprésent

QCM 14 – Un régime sans gluten sans diagnostic de maladie cœliaque :

a) est recommandé pour tous **b)** n'a pas de bénéfice démontré et peut coûter plus cher **c)** relève de la prévention quaternaire si on le déconseille **d)** est obligatoire en restauration collective

QCM 15 – Le repas gastronomique des Français :

a) est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2010 **b)** est un plan national de nutrition **c)** illustre la dimension culturelle de l'acte alimentaire **d)** a été supprimé

> **Corrigé – Corrigé expliqué des QCM**
>
> **1. a, b, d** (c définit la satiété). 2. **a, c**. 3. **a, b, d**. 4. **b, c, d**. 5. **a, d**. 6. **a, b, d**. 7. **c**. 8. **b**. 9. **a, d**. 10. **c**. 11. **a, c** (l'amer est initialement rejeté). 12. **a** (Insee, 2015). 13. **a, b, d**. 14. **b, c**. 15. **a, c**.

QCM 16 – Selon le modèle de Satter, l'enfant décide :

a) de ce qui est proposé **b)** s'il mange **c)** de la quantité qu'il mange **d)** de l'heure des repas

QCM 17 – Une collation se distingue du grignotage car elle :

a) est prévue **b)** répond à une faim **c)** est prise devant un écran **d)** est structurée

QCM 18 – Le régime de santé planétaire (EAT-Lancet, 2019) prévoit environ, par jour :

a) 14 g de viande rouge **b)** 150 g de viande rouge **c)** 75 g de légumineuses **d)** 300 g de légumes

QCM 19 – La DDM (date de durabilité minimale) signifie :

a) « à consommer jusqu'au » **b)** « à consommer de préférence avant » **c)** que le produit peut encore être consommé après la date **d)** que le produit est dangereux après la date

QCM 20 – La classification NOVA :

a) classe les aliments selon leur degré de transformation **b)** est identique au Nutri-Score **c)** comporte 4 groupes **d)** a été proposée au Brésil

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM complémentaires

16. b, c. 17. **a, b, d**. 18. **a, c, d**. 19. **b, c**. 20. **a, c, d**.

4.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : faim, rassasiement, satiété

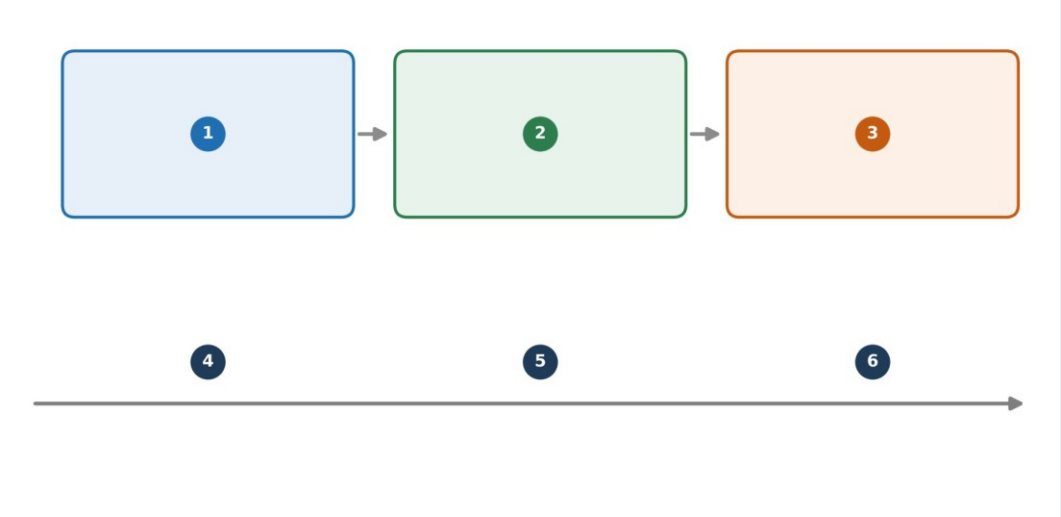


Figure 4.9 – Schéma à légender

Légendez les cases 1 à 3 (notion, moment, hormones) et les repères 4 à 6.

Corrigé

1. Faim (ghréline, estomac vide). 2. **Rassasiement** (CCK, distension gastrique, rassasiement sensoriel spécifique). 3. **Satiété** (GLP-1, PYY, insuline, leptine). 4. **Avant le repas**. 5. **Pendant le repas**. 6. **Entre deux repas**.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : la restriction cognitive

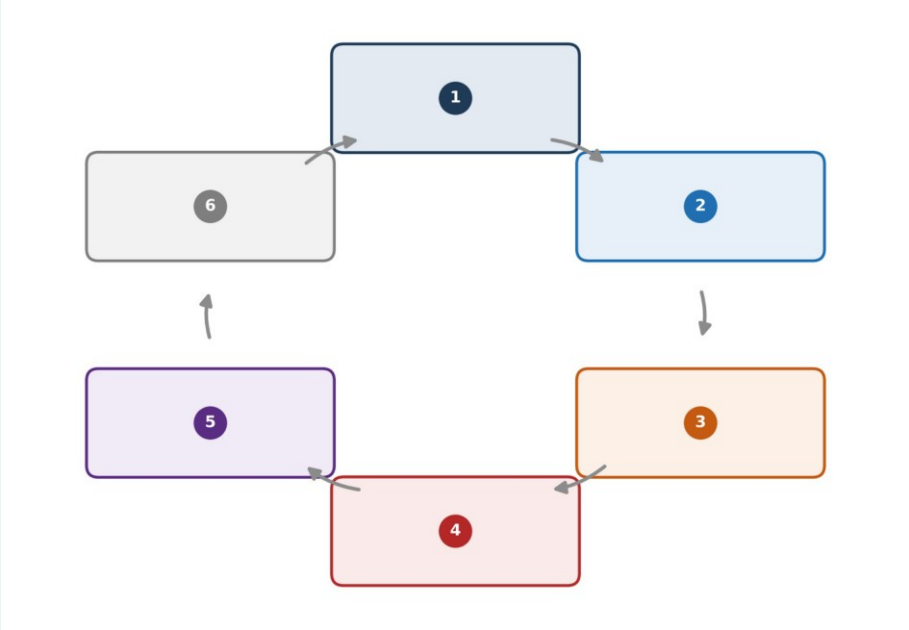


Figure 4.10 – Schéma à légender

Légendez les étapes 1 à 6 du cercle vicieux et proposez deux messages de prévention.

Corrigé

1. Insatisfaction corporelle / volonté de maigrir. 2. Restriction cognitive. 3. Frustration, faim, envies. 4. Perte de contrôle (craquage). 5. Culpabilité, baisse de l'estime de soi. 6. Reprise de poids, nouveaux régimes. **Messages** : « Aucun aliment n'est interdit : c'est la fréquence et la quantité qui comptent » ; « Écoutez votre faim et votre rassasiement : mangez lentement et savourez ».

À vous de jouer – Exercice 3 – Rôles de l'acte alimentaire

Pour chaque situation, identifiez le ou les rôles en jeu : a) le couscous du dimanche chez la grand-mère ; b) une boisson de récupération après un match ; c) une tablette de chocolat après une rupture amoureuse ; d) le repas de Noël ; e) le choix d'un produit en promotion.

Corrigé

a) Social, culturel et identitaire, hédonique. b) Biologique. c) Psychologique (réconfort), hédonique. d) Social, culturel (fête), hédonique. e) Économique.

À vous de jouer – Exercice 4 – Analyser un comportement

M. B., 45 ans, chauffeur routier, mange au volant, grignote quand il s'ennuie, saute le petit-déjeuner et mange beaucoup le soir. Identifiez les dérégulations et les déterminants, puis proposez trois conseils réalistes.

Corrigé

Dérégulations : grignotage et alimentation émotionnelle (ennui) ; externalité (manger par habitude au volant) ; déstructuration des prises (petit-déjeuner sauté, excès le soir). **Déterminants** : conditions de travail (horaires, sédentarité, offre des aires d'autoroute), solitude, temps. **Conseils** : préparer une glacière avec un repas et des collations prévues (fruits, fruits à coque, produits laitiers) ; faire de vraies pauses repas hors du camion ; prendre une collation le matin s'il n'a pas faim au réveil ; boire de l'eau à portée de main pour limiter

le grignotage d'ennui.

À vous de jouer – Exercice 5 – Sécuriser une pratique végétalienne

Une étudiante devient végétalienne. Listez les nutriments à surveiller et des sources végétales pour chacun.

Corrigé

- **Vitamine B12** : aucune source végétale fiable → **supplément obligatoire**.
- **Protéines** : légumineuses, soja (tofu, tempeh), céréales, fruits à coque ; associer légumineuses et céréales.
- **Fer** : légumineuses, céréales complètes, tofu, graines ; avec un aliment riche en vitamine C ; éviter le thé au repas.
- **Calcium** : boissons végétales enrichies, tofu au calcium, eaux minérales riches en calcium, choux, amandes.
- **Vitamine D** : exposition solaire, aliments enrichis, supplémentation selon avis médical.
- **Iode** : sel iodé (en quantité modérée), algues avec prudence.
- **Oméga-3** : huile de colza, noix, graines de lin ; éventuellement huile d'algues.
- **Zinc** : légumineuses, céréales complètes, graines.

À vous de jouer – Exercice 6 – Adapter un atelier pendant le Ramadan

Un atelier hebdomadaire a lieu à 17 h dans un centre social dont plusieurs participantes jeûnent. Proposez des adaptations.

Corrigé

Décaler l'atelier en soirée (rupture du jeûne) ou proposer une séance sans dégustation sur place avec préparation à emporter ; thème « rupture du jeûne équilibrée » (dattes et eau, soupe de légumes et de lentilles, plat complet, fruits) ; conseils d'hydratation entre le coucher et le lever du soleil ; prise en compte de la fatigue ; respect total des choix de chacune (certaines ne jeûnent pas).

À vous de jouer – Exercice 7 – Interpréter des données d'évolution

La part de l'alimentation dans la consommation des ménages est passée de 35 % en 1960 à 20 % en 2014. Calculez la baisse en points et en pourcentage, et proposez deux explications.

Corrigé

Baisse en points : 35 − 20 = **15 points**. Baisse relative : 15 / 35 × 100 = **42,9 %**. Explications : hausse des revenus plus rapide que celle des dépenses alimentaires (loi d'Engel : la part de l'alimentation diminue quand le revenu augmente) ; développement d'autres postes (logement, transports, loisirs, communication) ; baisse relative des prix agricoles. Cette moyenne masque des écarts : la part de l'alimentation reste plus élevée chez les ménages modestes.

À vous de jouer – Exercice 8 – Concevoir une activité de pleine conscience

Rédigez le déroulé d'une dégustation en pleine conscience de 15 minutes avec un carré de chocolat ou un quartier d'orange.

Corrigé

1. Installation au calme, sans écran (1 min). 2. Observer l'aliment : couleur, forme, brillance (2 min). 3. Le sentir, noter les odeurs (2 min). 4. Le mettre en bouche sans croquer, sentir la texture et les saveurs qui évoluent (3 min). 5. Mâcher lentement, avaler, noter l'arrière-goût (3 min). 6. Évaluer son envie d'un deuxième morceau sur une échelle de 0 à 10 (1 min). 7. Échanges : qu'avez-vous remarqué ? qu'est-ce qui change quand on mange lentement ? (3 min).

À vous de jouer – Exercice 9 – Échelle de la faim

Construisez une échelle de la faim de 0 à 10 utilisable avec des enfants (mots et pictogrammes) et expliquez comment l'utiliser.

Corrigé

0 : « J'ai très faim, j'ai mal au ventre » ; 2 : « J'ai faim » ; 4 : « J'ai un petit creux » ; 5 : « Je n'ai ni faim ni plus faim » ; 7 : « Je n'ai plus faim, c'est bien » ; 9 : « J'ai trop mangé, le ventre est lourd » ; 10 : « Je me sens mal ». Avec des visages dessinés et un ventre qui se remplit. **Utilisation** : avant le goûter et en fin de repas, l'enfant montre sa position ; on l'aide à commencer à manger vers 2-4 et à s'arrêter vers 7, sans obligation de finir.

À vous de jouer – Exercice 10 – Choisir des recettes compatibles

Un atelier réunit : une famille végétarienne, deux familles mangeant halal, un enfant allergique à l'arachide. Proposez un menu commun et justifiez.

Corrigé

Entrée : salade de lentilles, carottes et persil ; plat : curry de pois chiches et légumes de saison au lait de coco avec riz ; dessert : compote de pommes à la cannelle et biscuits maison sans arachide. **Justification** : plat végétarien (convient à tous, sans question de viande halal) ; aucun ingrédient à base d'arachide et vérification des étiquettes (traces) ; légumineuses + céréales (complémentarité protéique) ; coût faible ; plaisir et convivialité.

4.8.3 Questions de réflexion

À vous de jouer – Question 1

Pourquoi le plaisir doit-il être intégré à l'éducation nutritionnelle ?

Corrigé

Parce que le plaisir est un rôle central de l'acte alimentaire, qu'il participe à la régulation (rassasiement sensoriel), à la convivialité et à l'adhésion aux conseils ; un message qui le supprime favorise la restriction cognitive et l'abandon. Le modèle français, qui associe plaisir et repas partagé, est considéré comme protecteur.

À vous de jouer – Question 2

Les régimes restrictifs sont-ils une solution de santé publique à l'obésité ?

Corrigé

Non : ils exposent à la restriction cognitive, à l'effet yo-yo, à des carences et à des TCA, et ne modifient pas l'environnement obésogène ni les déterminants sociaux. La santé publique privilégie l'action sur l'environnement (offre, prix, marketing), la promotion d'une alimentation favorable et du plaisir, l'activité physique, et la non-stigmatisation ; la prise en charge individuelle de l'obésité relève du soin, coordonné par le médecin.

À vous de jouer – Question 3

Comment concilier respect des pratiques alimentaires et recommandations nutritionnelles ?

Corrigé

En distinguant ce qui relève du **choix** de la personne (végétarisme, religion, culture), que l'on respecte, et ce qui relève de la **sécurité** nutritionnelle (B12 chez le végétalien, protéines chez la personne âgée), que l'on garantit ; en adaptant les repères à la pratique (sources de fer végétales, plats halal équilibrés) et en négociant des changements compatibles.

4.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – La résidence étudiante

Une résidence universitaire de 300 étudiants : nombreux repas sautés, livraisons de repas le soir, régimes « healthy » vus sur les réseaux, quelques étudiants végétaliens, budget serré, kitchenettes avec deux plaques et un micro-ondes.

1. Identifiez les rôles de l'acte alimentaire négligés et les dérégulations possibles.
2. Analysez les déterminants.
3. Proposez un cycle de 3 ateliers.
4. Comment aborder le végétalisme sans jugement ?
5. Proposez deux indicateurs d'évaluation.

Corrigé

1. Rôles négligés : **social** (repas seuls), **biologique** (repas sautés) ; dérégulations : déstructuration des prises, grignotage, restriction cognitive liée aux régimes « healthy », externalité (livraisons).
2. Déterminants : budget, équipement limité, temps, rythme des études, isolement, influence des réseaux sociaux, offre de livraison.
3. Atelier 1 « Cuisiner en kitchenette » (deux plaques, micro-ondes : bowls complets en 15 min). Atelier 2 « Manger avec plaisir, sans régime » (sensations, pleine conscience, décryptage des contenus des réseaux). Atelier 3 « Repas partagé végétal et économique » (légumineuses, batch cooking, convivialité).
4. Respecter le choix ; informer sur la B12 et les nutriments à surveiller ; proposer des recettes végétaliennes complètes ; orienter vers le service de santé universitaire si besoin.
5. Proportion d'étudiants déclarant sauter un repas par jour (avant/après) ; nombre de participants et satisfaction ; nombre de recettes refaites déclarées.

4.8.5 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Quelle différence entre rassasiement et satiété ? »

Corrigé

Le rassasiement se développe pendant le repas et conduit à l'arrêter ; la satiété est l'absence de faim après le repas, jusqu'au repas suivant.

Mise en situation – MSE 2

Une participante dit : « Je ne mange plus de pain, ça fait grossir. »

Corrigé

Je l'écoute, je reconnais son objectif, j'explique que le pain (surtout complet) est un féculent recommandé et rassasiant, que c'est la quantité et ce qu'on y ajoute qui comptent, et je l'alerte doucement sur le risque de « craquage » lié aux interdits.

Mise en situation – MSE 3

Un parent s'inquiète : son enfant de 3 ans refuse tous les légumes.

Corrigé

Je le rassure : la néophobie est normale à cet âge ; je conseille de proposer régulièrement les légumes sans forcer ni récompenser, de les manger soi-même devant l'enfant, de varier les présentations et de l'impliquer dans la préparation.

Mise en situation – MSE 4

Un élève végétalien de 16 ans demande si son alimentation est « saine ».

Corrigé

Je respecte son choix et vérifie les points essentiels : supplément de vitamine B12 indispensable, sources de protéines, calcium, fer, iode ; je l'encourage à en parler à son médecin pour un suivi, compte tenu de sa croissance.

Mise en situation – MSE 5

Qu'est-ce que l'oralité alimentaire ?

Corrigé

L'ensemble des fonctions de la bouche liées à l'alimentation (succion, déglutition, mastication, goût), qui se construit de la vie fœtale à l'enfance ; certains enfants présentent des troubles de l'oralité nécessitant une prise en charge spécialisée.

Mise en situation – MSE 6

Un participant explique qu'il mange « pour se calmer ».

Corrigé

C'est de l'alimentation émotionnelle ; sans juger, je propose de repérer les situations déclenchantes et d'autres réponses possibles (marcher, respirer, appeler quelqu'un), et j'oriente vers un professionnel si la souffrance est importante.

Mise en situation – MSE 7

Pourquoi proposer des repas partagés à des personnes âgées ?

Corrigé

Parce que la convivialité stimule l'appétit (facilitation sociale), réduit l'isolement et prévient la dénutrition ; le rôle social de l'acte alimentaire est un levier de santé.

Mise en situation – MSE 8

Une collègue veut supprimer les desserts dans un atelier pour des enfants.

Corrigé

Je propose plutôt des desserts maison peu sucrés et des fruits ; supprimer les desserts les rend plus désirables et ignore le rôle hédonique ; on peut travailler la quantité et la qualité sans interdiction.

Mise en situation – MSE 9

Un participant suit un jeûne intermittent vu sur internet et demande votre avis.

Corrigé

J'explique que les preuves de supériorité à long terme sont limitées, que la pratique peut convenir à certains mais présente des risques (restriction, craquages) et des contre-indications (diabète traité, grossesse, TCA, adolescence) ; je l'invite à en parler à son médecin s'il a une pathologie.

Mise en situation – MSE 10

Comment tenez-vous compte des pratiques halal dans un atelier ?

Corrigé

Je recueille les pratiques à l'inscription, je propose des recettes sans porc ni alcool, j'achète la viande halal si nécessaire ou je privilégie des plats végétariens qui conviennent à tous, et je vérifie les ingrédients cachés (gélatine, arômes).

Mise en situation – MSE 11

Donnez un exemple de syncrétisme culinaire.

Corrigé

Un couscous aux légumes de saison français, une pizza aux légumes du marché et épices orientales, des galettes de sarrasin garnies à la façon d'un taco.

Mise en situation – MSE 12

Pourquoi ne pas obliger un enfant à finir son assiette ?

Corrigé

Parce que cela l'habitue à ignorer son rassasiement et favorise l'externalité ; mieux vaut servir de petites portions et permettre de se resservir.

4.8.6 Exercices complémentaires

À vous de jouer – Exercice 11 – Répartition de l'énergie

Une personne âgée consomme 1 500 kcal : petit-déjeuner 450 kcal, déjeuner 600 kcal, goûter 0, dîner 300 kcal, prises nocturnes 150 kcal. Calculez les parts et proposez des ajustements pour prévenir la dénutrition.

Corrigé

Total : 450 + 600 + 0 + 300 + 150 = **1 500** . Parts : petit-déjeuner **30 %** ; déjeuner **40 %** ; goûter **0 %** ; dîner **20** ✓ % ; nuit **10 %.** Ajustements : ajouter un goûter enrichi (laitage, pain, fruit : environ 250 kcal), enrichir le dîner (fromage râpé, œuf), conserver le petit-déjeuner copieux (atout), vérifier le jeûne nocturne (moins de 12 heures recommandées en institution) ; objectif : augmenter l'apport total (pesée régulière, avis médical).

À vous de jouer – Exercice 12 – Exposition répétée

Une crèche veut faire accepter les lentilles. Elles sont proposées 3 fois par semaine sous des formes variées. Combien de semaines pour 12 expositions ? Résultats : 20 enfants ; acceptation à la 1re exposition 4, à la 6e 9, à la 12e 15. Calculez les taux et commentez.

Corrigé

12 / 3 = **4 semaines**. Taux : 4 / 20 = **20 %** ; 9 / 20 = **45 %** ; 15 / 20 = **75 %.** L'acceptation progresse avec la répétition, sans pression ; il reste 25 % d'enfants qui refusent : poursuivre, varier les présentations (purée, soupe, galettes), associer les parents.

À vous de jouer – Exercice 13 – Empreinte carbone et coût

Une cantine sert 400 repas par jour, 4 jours par semaine, avec un plat de bœuf (100 g) une fois par semaine. Elle le remplace par un chili de haricots rouges (portion de haricots secs : 60 g, environ 0,07 kg CO2e). Calculez la réduction d'émissions sur une année scolaire de 36 semaines (bœuf : 2,8 kg CO2e par portion).

Corrigé

Réduction par repas : 2,8 − 0,07 = **2,73 kg** CO2e. Par semaine : 2,73 × 400 = **1 092 kg**. Sur 36 semaines : 1 092 × 36 = **39 312 kg**, soit environ **39,3 tonnes** d'équivalent CO2 (ordre de grandeur). Le plat végétarien hebdomadaire est d'ailleurs obligatoire en restauration scolaire (loi EGalim, puis loi Climat et résilience) ;

condition de réussite : une recette appréciée (chapitre 4, annale 3).

À vous de jouer – Exercice 14 – Questionnaire de fréquence

Sur 50 lycéens, nombre de jours avec petit-déjeuner la semaine d'école précédente (5 jours) : 0 jour : 9 ; 1-2 jours : 8 ; 3-4 jours : 12 ; 5 jours : 21. Calculez les pourcentages, la part de lycéens prenant un petit-déjeuner au moins 4 jours sur 5 si 7 des 12 lycéens de la classe « 3-4 jours » en prennent 4, et commentez.

Corrigé

Vérification : 9 + 8 + 12 + 21 = **50** . 0 jour **18 %** ; 1-2 jours **16 %** ; 3-4 jours **24 %** ; 5 jours **42 %**. Au moins 4 jours ✓ : 21 + 7 = **28** ; 28 / 50 × 100 = **56 %**. Plus d'un lycéen sur six ne prend jamais de petit-déjeuner les jours d'école : action prioritaire (petit-déjeuner rapide, à emporter, horaires du bus).

À vous de jouer – Exercice 15 – Anti-gaspillage

Une famille jette chaque semaine 1,2 kg d'aliments (pain, fruits abîmés, restes) d'une valeur moyenne de 3,50 €/kg. Calculez la perte annuelle en kg et en euros et proposez 4 gestes.

Corrigé

1,2 × 52 = **62,4 kg** par an ; 62,4 × 3,50 = **218,40 €** par an. Gestes : liste de courses et menus de la semaine ; rangement (premier entré, premier sorti) ; comprendre DLC et DDM ; recettes de restes (pain perdu, compote, soupe, gratin) ; congeler les portions en trop.

4.8.7 Exercices d'approfondissement

À vous de jouer – Exercice 16 – Adapter une recette aux pratiques religieuses

Une recette de quiche lorraine (lardons, crème, lait, œufs, pâte au beurre) doit être proposée à un groupe comprenant des personnes musulmanes, juives pratiquantes et végétariennes. Proposez une adaptation unique.

Corrigé

Quiche aux poireaux et fromage de chèvre (sans viande) : convient aux personnes musulmanes et végétariennes ; pour les personnes juives pratiquantes, plat lacté sans viande, donc compatible avec la séparation lait/viande (sous réserve des exigences de cacheroute des ustensiles et des produits, à discuter avec elles) ; vérifier l'absence de gélatine ou d'alcool dans les ingrédients ; signaler les allergènes (lait, œufs, gluten).

À vous de jouer – Exercice 17 – Repérer et orienter

Lors d'un atelier avec des lycéennes, l'une d'elles dit ne manger « qu'une pomme le midi » et a beaucoup maigri selon son amie. Décrivez votre conduite, en distinguant ce que vous faites et ce que vous ne faites pas.

Corrigé

Je fais : je ne commente pas devant le groupe ; je parle avec elle en privé, avec bienveillance, sans jugement ni diagnostic (« J'ai entendu que tu manges peu le midi, comment ça va pour toi ? ») ; j'informe l'infirmière

scolaire, dans le respect de la confidentialité et des règles de l'établissement ; je lui indique les ressources. **Je ne fais pas** : peser, donner un régime « pour reprendre du poids », poser un diagnostic de TCA, en parler à la classe, faire remplir un questionnaire de repérage en public.

4.9 Glossaire

Terme	Définition
Alimentation émotionnelle	Prise alimentaire en réponse à des émotions plutôt qu'à la faim
ARFID	Trouble de restriction ou d'évitement de l'ingestion des aliments, sans préoccupation pour le poids
Besoin	Nécessité physiologique d'apports en énergie, eau et nutriments
Comportement alimentaire	Ensemble des conduites vis-à-vis de l'alimentation (choix, prises, rythmes, quantités, contexte)
Environnement obésogène	Environnement favorisant l'excès d'apports et la sédentarité
Externalité	Prise alimentaire guidée par des signaux extérieurs
Faim	Sensation physiologique poussant à manger
Flexitarisme	Réduction volontaire de la consommation de viande sans l'exclure
Ghréline	Hormone gastrique orexigène
Leptine	Hormone du tissu adipeux signalant les réserves énergétiques
Oralité	Fonctions de la bouche (succion, déglutition, mastication, goût, langage)
Pulsion	Poussée interne peu contrôlée vers la prise alimentaire
Rassasiement	Processus conduisant à l'arrêt de la prise pendant le repas
Rassasiement sensoriel spécifique	Baisse du plaisir pour un aliment consommé, sans baisse pour les autres
Restriction cognitive	Contrôle de l'alimentation par des règles mentales plutôt que par les sensations
Satiété	Absence de faim après le repas, jusqu'au suivant
Syncrétisme culinaire	Combinaison d'éléments de cultures culinaires différentes
Troubles du comportement alimentaire (TCA)	Troubles psychiatriques : anorexie mentale, boulimie, hyperphagie boulimique, ARFID
Végétalisme / véganisme	Exclusion de tous les produits animaux (véganisme : mode de vie)
Végétarisme	Exclusion de la viande et du poisson
Alimentation durable	Alimentation saine, accessible, culturellement acceptable et respectueuse des écosystèmes (FAO, 2010)
Chrononutrition	Étude des liens entre horaires des prises alimentaires, rythmes biologiques et santé
Collation	Prise alimentaire prévue, entre deux repas, répondant à une faim
DDM / DLC	Date de durabilité minimale (« de préférence avant ») / date limite de consommation (« jusqu'au »)
Diversification	Introduction progressive d'aliments autres que le lait chez le nourrisson
Exposition répétée	Présentation répétée d'un aliment pour favoriser son acceptation
Habitude	Comportement automatique déclenché par un contexte

Terme	Définition
NOVA	Classification des aliments selon le degré de transformation (4 groupes)
Partage des responsabilités	Modèle de Satter : le parent décide quoi, quand, où ; l'enfant si et combien
Rythme alimentaire	Nombre, horaires et régularité des prises alimentaires

4.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Rôles de l'acte alimentaire, sociologie	[1] Poulain ; [2] Fischler et Masson ; [3] UNESCO
Régulation	[4] Blundell ; [5] Collège des enseignants de nutrition
Dérégulations, TCA	[6] Herman et Polivy ; [7] HAS anorexie ; [8] HAS boulimie et hyperphagie
Évolution des pratiques	[9] Insee 2015 ; [10] CNA avis 90
Pratiques actuelles	[11] FranceAgriMer/Ifop 2020 ; [12] ANSES ; [13] Santé publique France repères 2019 ; [14] HCSP 2025
Approches non restrictives	[15] GROS ; [16] Tribole et Resch

4.12 Bibliographie numérotée

1. Poulain J.-P. *Sociologies de l'alimentation*. Paris, PUF, 2002 (rééd. 2017).
2. Fischler C., Masson E. *Manger : Français, Européens et Américains face à l'alimentation*. Paris, Odile Jacob, 2008.
3. UNESCO. « Le repas gastronomique des Français », inscription au patrimoine culturel immatériel, 2010.
4. Blundell J. E. et coll. « Appetite control: methodological aspects of the evaluation of foods ». *Obesity Reviews*, 2010, 11 (3), p. 251-270.
5. Collège des enseignants de nutrition. *Nutrition* (référentiel). Elsevier Masson, dernière édition.
6. Herman C. P., Polivy J. « Anxiety, restraint, and eating behavior ». *Journal of Abnormal Psychology*, 1975, 84 (6), p. 666-672.
7. HAS. *Anorexie mentale : prise en charge*. Recommandation de bonne pratique, 2010.
8. HAS. *Boulimie et hyperphagie boulimique : repérage et éléments généraux de prise en charge*. Recommandation de bonne pratique, juin 2019.
9. Larochette B., Sanchez-Gonzalez J. « Cinquante ans de consommation alimentaire : une croissance modérée, mais de profonds changements ». *Insee Première*, n° 1568, octobre 2015.
10. Conseil national de l'alimentation. *Nouveaux comportements alimentaires*. Avis n° 90, 2022.
11. FranceAgriMer, Ifop. *Végétariens et flexitariens en France en 2020*. 2021.
12. ANSES. *Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires*. 2016.
13. Santé publique France. *Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes*. 2019.
14. Haut Conseil de la santé publique. *Recommandations pour l'élaboration du 5e PNNS*. Juin 2025.
15. Apfeldorfer G., Zermati J.-P. *Maigrir sans régime*. Paris, Odile Jacob (approche du GROS).
16. Tribole E., Resch E. *Intuitive Eating*. New York, St Martin's Press, 1995 (rééd.).
17. Schachter S. « Obesity and eating ». *Science*, 1968, 161, p. 751-756.

18. AFSSA. *Avis relatif à la collation matinale à l'école*. 23 janvier 2004.

19. Santé publique France. *Pas à pas, votre enfant mange comme un grand* et recommandations sur la diversification alimentaire. 2021.

20. Satter E. *Child of Mine: Feeding with Love and Good Sense*. Bull Publishing, éd. révisée 2000.

21. Willett W. et coll. « Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems ». *The Lancet*, 2019, 393, p. 447-492 ; mise à jour : Rockström J. et coll., *The Lancet*, octobre 2025.

22. ADEME. *Agribalyse* (base de données d'impacts environnementaux des aliments), *agribalyse.ademe.fr*.

23. ADEME. *État des lieux des masses de gaspillages alimentaires et de sa gestion aux différentes étapes de la chaîne alimentaire*. 2016. SDES. *Déchets alimentaires en France et dans l'Union européenne en 2023*. 30 octobre 2025.

24. Monteiro C. A. et coll. « Ultra-processed foods: what they are and how to identify them ». *Public Health Nutrition*, 2019, 22 (5), p. 936-941.

25. Lally P. et coll. « How are habits formed: modelling habit formation in the real world ». *European Journal of Social Psychology*, 2010, 40 (6), p. 998-1009.

26. FAO. *Sustainable Diets and Biodiversity*. Rome, 2012 (actes du symposium de 2010).

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 4.2.2)

27. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE

CHAPITRE

04

Pratiques et comportements alimentaires

Rôles de l'acte alimentaire | Régulation | Pratiques actuelles

DANS CE VOLUME

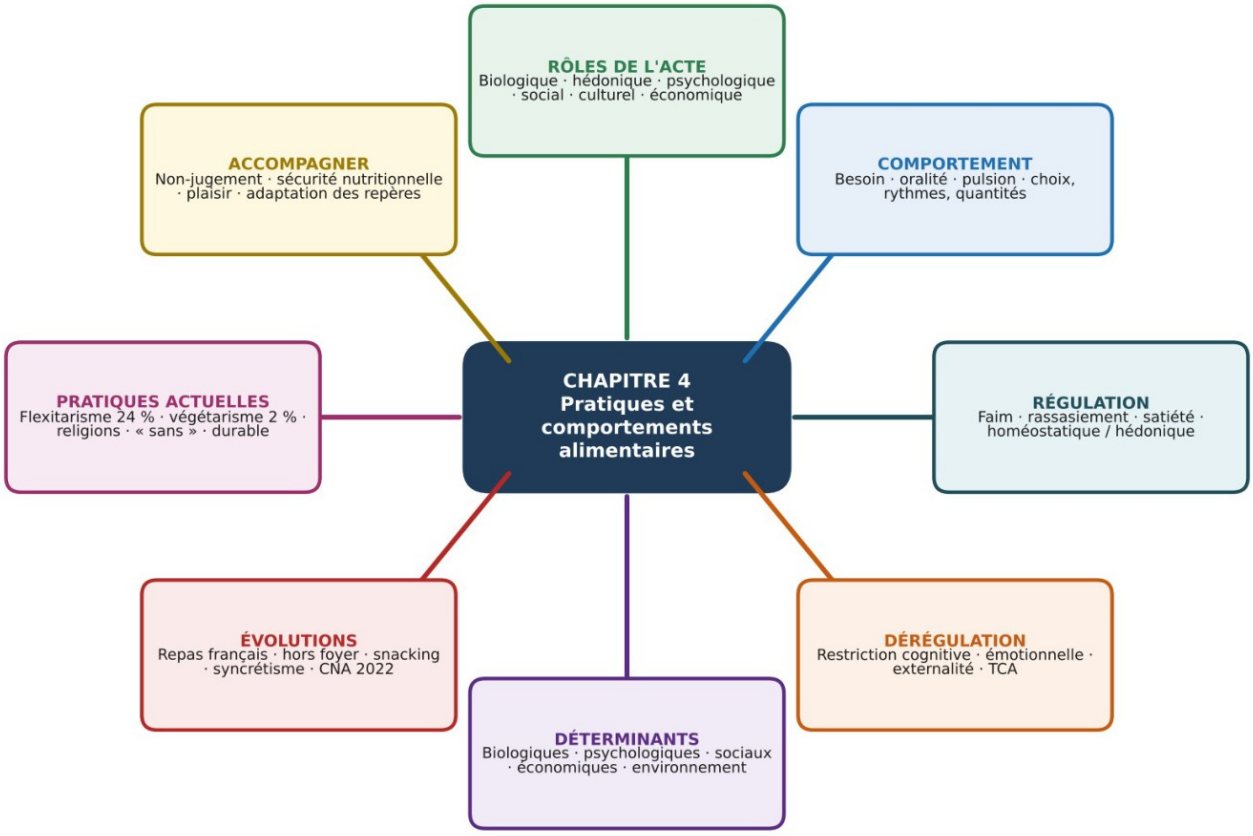
- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

Sommaire

Fiche de révision du chapitre 4 102
1. Les définitions à savoir 102
2. Les rôles de l'acte alimentaire 102
3. Pratiques et vigilance 103
4. Chiffres-clés 103
5. Les pièges 103
6. Auto-test 103
7. Flashcards 103
Compléments du chapitre enrichi 104
Fiches-outils du chapitre 4 104
O4.1 – Recueil des pratiques alimentaires d'un groupe 104
O4.2 – Échelle de la faim et de la satiété 105
O4.3 – Grille d'analyse d'un comportement alimentaire 105
O4.4 – Compatibilité d'une recette avec les pratiques du groupe 105
O4.5 – Repérage et orientation : conduite à tenir 106

Fiche de révision du chapitre 4

Pratiques et comportements alimentaires



Carte mentale du chapitre 4

1. Les définitions à savoir

Notion	Définition
Comportement alimentaire	Conduites vis-à-vis de l'alimentation : choix, prises, rythmes, quantités, contexte
Faim / rassasiement / satiété	Avant (ghréline) / pendant, arrêt de la prise (CCK, distension) / après, jusqu'au repas suivant (GLP- 1, PYY, insuline, leptine)
Régulation homéostatique / hédonique	Hypothalamus, équilibre énergétique / récompense, dopamine, plaisir
Restriction cognitive	Règles mentales au lieu des sensations (Herman et Polivy, 1975)
Externalité	Manger en réponse à des signaux extérieurs
Syncrétisme culinaire	Combinaison de cultures culinaires
Flexitarisme	Réduction volontaire de la viande (24 % en 2020)

2. Les rôles de l'acte alimentaire

Biologique · hédonique · psychologique · social · culturel et identitaire · économique.

3. Pratiques et vigilance

Pratique	Point de vigilance clé
Végétarisme	Fer (+ vitamine C), oméga-3, zinc, iode
Végétalisme	Vitamine B12 : supplémentation obligatoire ; calcium, vitamine D, iode, protéines
Religions	Respect des interdits ; Ramadan : hydratation, repas de rupture équilibré
« Sans gluten » sans diagnostic	Pas de bénéfice démontré, surcoût
Régimes à la mode, jeûne	Restriction, carences, TCA

4. Chiffres-clés

- Part de l'alimentation dans la consommation : 35 % (1960) → 20 % (2014) (Insee, 2015) ; 12,5 % en 2025 pour les seuls aliments et boissons non alcoolisées (Insee, 2026).
- 2 % de végétariens/végétaliens, 24 % de flexitariens, 8 % limitant la viande (Ifop/FranceAgriMer, 2020).
- Néophobie maximale de 2 à 6 ans ; 8 à 15 expositions.
- Repas gastronomique des Français : UNESCO 2010.

5. Les pièges

Attention

- Confondre rassasiement et satiété.
- Prescrire ou encourager des régimes restrictifs en santé publique.
- Classer des aliments en « interdits ».
- Juger une pratique (végétarisme, religion) au lieu de la sécuriser.
- Poser un diagnostic de TCA (on repère et on oriente).

6. Auto-test

1. Hormone de la faim ? 2. Hormone des réserves ? 3. Moment du rassasiement ? 4. Étapes du cercle de la restriction ? 5. Nutriment à supplémenter chez le végétalien ? 6. Part des flexitariens ? 7. Qu'est-ce que l'externalité ? 8. Deux conseils pour favoriser le rassasiement ? 9. Que signifie ARFID ? 10. Exemple de syncrétisme ?

Réponses : 1. Ghréline – 2. Leptine – 3. Pendant le repas – 4. Insatisfaction, restriction, frustration, craquage, culpabilité, reprise de poids – 5. Vitamine B12 – 6. 24 % – 7. Manger selon des signaux extérieurs – 8. Manger lentement, fibres et protéines, sans écran – 9. Trouble de restriction/évitement de l'ingestion des aliments – 10. Couscous aux légumes de saison français.

7. Flashcards

Recto : Rassasiement sensoriel spécifique ?	Verso : Baisse du plaisir pour l'aliment consommé, pas pour les autres
Recto : Environnement obésogène ?	Verso : Portions, offre palatable, marketing, sédentarité
Recto : Loi d'Engel ?	Verso : La part de l'alimentation dans le budget baisse quand le revenu augmente
Recto : Recommandations HAS TCA ?	Verso : Anorexie mentale (2010) ; boulimie et hyperphagie boulimique (2019)

Recto : Rassasiement sensoriel spécifique ?	Verso : Baisse du plaisir pour l'aliment consommé, pas pour les autres
Recto : Cinq principes d'accompagnement ?	Verso : Comprendre, respecter, partir de l'existant, plaisir, sécuriser et orienter
Recto : Facilitation sociale ?	Verso : On mange plus à plusieurs : utile contre la dénutrition

Compléments du chapitre enrichi

Notion	À retenir
Rythmes	Repas, collation (prévue, faim), grignotage ; petit-déjeuner 20-25 %, déjeuner 35-40 %, goûter 10-15 %, dîner 25-30 % ; pas de collation à 10 h si petit-déjeuner (AFSSA, 2004)
Enfant	Diversification entre 4 et 6 mois ; néophobie 2-6 ans ; 8 à 15 expositions ; Satter : parent quoi/quand/où, enfant si/combien
Mesure	Rappel de 24 h, carnet, fréquence, observation, pesée des restes
Durabilité	FAO (2010) ; EAT-Lancet (2019, mise à jour 2025) ≈ 14 g/jour de viande rouge ; bœuf ≈ 50 × lentilles en CO2e par portion ; gaspillage ≈ 3,8 Mt comestibles en 2023 (SDES)
TCA	Anorexie ≈ 0,9 % des femmes, boulimie ≈ 1,5 %, hyperphagie ≈ 3,5 % (vie entière) ; prévention sans poids ; repérer et orienter (FFAB)
Précarité	Stratégies : qualité sacrifiée, priorité aux enfants, faire durer, aide alimentaire, plaisir préservé ; reconnaître les compétences

Fiches-outils du chapitre 4

Outil	Intitulé	Utilité
O4.1	Recueil des pratiques alimentaires d'un groupe	Adapter l'action aux pratiques (régimes, religions, rythmes)
O4.2	Échelle de la faim et de la satiété	Atelier sensations (enfants, adultes)
O4.3	Grille d'analyse d'un comportement alimentaire	Identifier déterminants et dérégulations
O4.4	Compatibilité d'une recette avec les pratiques du groupe	Choisir des recettes communes
O4.5	Repérage et orientation (signes d'alerte)	Conduite à tenir en action collective

O4.1 – Recueil des pratiques alimentaires d'un groupe

Pratique	Nombre de participants	Conséquence pour l'atelier
Sans porc / halal		
Casher		
Végétarien / pescétarien		
Végétalien		
Jeûne (période, horaires)		
Allergies (préciser)		
Intolérances, maladie cœliaque		
Textures adaptées		

Pratique	Nombre de participants	Conséquence pour l'atelier
Autre		

Recueil avec l'accord des personnes ; données de santé à protéger (RGPD).

O4.2 – Échelle de la faim et de la satiété

Niveau	Ce que je ressens	Que faire ?
0	Très faim, malaise, irritabilité	Manger sans attendre
2	Faim nette, ventre qui gargouille	C'est le bon moment pour manger
4	Petit creux	Je peux manger ou attendre un peu
5	Ni faim ni rassasié	Pas besoin de manger
7	Rassasié, satisfait	C'est le bon moment pour s'arrêter
9	Trop mangé, ventre lourd	Repérer ce qui m'a poussé à continuer
10	Mal, nausée	Prendre le temps la prochaine fois

O4.3 – Grille d'analyse d'un comportement alimentaire

Rubrique	Observations
Comportement observé (quoi, quand,	
combien, où, avec qui)	
Rôles de l'acte alimentaire en jeu	
Régulation (faim, rassasiement, satiété	
respectés ?)	
Dérégulations possibles (restriction,	
émotionnelle, externalité, grignotage)	
Déterminants (biologiques,	
psychologiques, sociaux, économiques,	
environnement)	
Leviers éducatifs et environnementaux	
Signes d'alerte nécessitant une	
orientation	

orientation

O4.4 – Compatibilité d'une recette avec les pratiques du groupe

Recette	Sans porc / halal	Végétarien	Végétalien	Sans gluten	Sans lait	Allergènes à signaler
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	

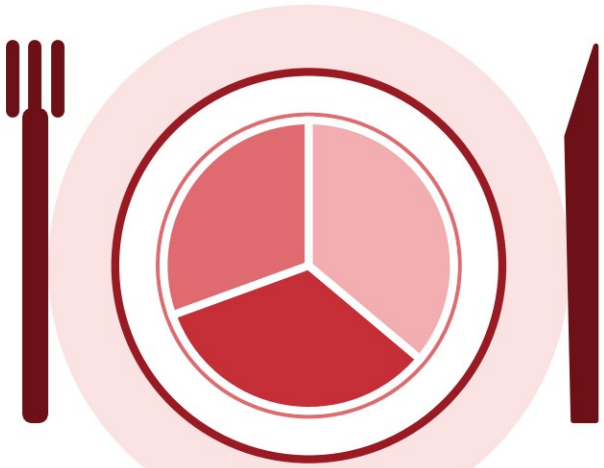
O4.5 – Repérage et orientation : conduite à tenir

Signe observé ou confié	Conduite à tenir
Perte de poids importante, restriction sévère, peur intense de grossir	Ne pas commenter devant le groupe ; en parler en privé avec bienveillance ; informer le référent de la structure ; orienter vers le médecin traitant
Crises de « craquage », vomissements, utilisation de laxatifs	Même conduite ; informer des ressources (médecin, structures spécialisées en TCA)
Perte d'appétit et de poids chez une personne âgée	Signaler (avec accord) au médecin traitant ou au service d'aide ; proposer une pesée
Pathologie déclarée (diabète, insuffisance rénale…)	Orienter vers une consultation diététique (BC1), ne pas prescrire de régime
Détresse psychologique	Informer immédiatement le référent ; ressources d'écoute ; ne pas rester seul(e)

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES



CHAPITRE

04

Pratiques et comportements alimentaires

Rôles de l'acte alimentaire | Régulation | Pratiques actuelles

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 4 110
Mode d'emploi du cahier 110
Partie 1 – Les rôles de l'acte alimentaire et le comportement alimentaire 111
Exercice 4.1 – Légender les rôles de l'acte alimentaire (8 points) 112
Exercice 4.2 – Reconnaître les rôles dans la parole des résidents (10 points) 114
Exercice 4.3 – Besoin, envie, oralité, pulsion (8 points) 116
Exercice 4.4 – Réécrire une affiche « 100 % biologique » (10 points) 117
Exercice 4.5 – La part de l'alimentation dans le budget (12 points) 119
Exercice 4.6 – Manger seul au foyer de jeunes travailleurs (16 points) 121
Corrigés de la partie 1 123
Partie 2 – La régulation du comportement alimentaire 126
Exercice 4.7 – Légender faim, rassasiement et satiété (8 points) 127
Exercice 4.8 – Légender les systèmes de régulation (10 points) 128
Exercice 4.9 – Manger vite, manger lentement (10 points) 130
Exercice 4.10 – Le rassasiement sensoriel spécifique au buffet (10 points) 131
Exercice 4.11 – La taille des portions au self (12 points) 133
Exercice 4.12 – Deux déjeuners, deux densités énergétiques (16 points) 135
Corrigés de la partie 2 137
Partie 3 – Les dérégulations : restriction, émotions, troubles du comportement alimentaire 140
Exercice 4.13 – Légender le cercle de la restriction cognitive (8 points) 141
Exercice 4.14 – Nommer le phénomène (10 points) 143
Exercice 4.15 – Coter un questionnaire sur les règles alimentaires (10 points) 145
Exercice 4.16 – Estimer le nombre d'étudiants concernés par un TCA (12 points) 147
Exercice 4.17 – Analyser une publication « détox » (12 points) 149
Exercice 4.18 – « Faire le poids » en section sportive de judo (16 points) 151
Corrigés de la partie 3 153
Partie 4 – Les déterminants du comportement alimentaire 156
Exercice 4.19 – Légender les déterminants du comportement alimentaire (8 points) 157
Exercice 4.20 – Les déterminants d'une personne (10 points) 159
Exercice 4.21 – L'environnement autour d'un lycée professionnel (12 points) 160
Exercice 4.22 – Les stratégies des familles à l'épicerie solidaire (10 points) 162
Exercice 4.23 – Le prix des calories (12 points) 163
Exercice 4.24 – Les jeunes de la mission locale (16 points) 165
Corrigés de la partie 4 167
Partie 5 – Évolution des pratiques et pratiques alimentaires actuelles 170
Exercice 4.25 – Deux générations à table (12 points) 171
Exercice 4.26 – Le syncrétisme culinaire au marché (8 points) 173
Exercice 4.27 – Reconnaître les pratiques et leurs points de vigilance (10 points) 174
Exercice 4.28 – Le fer d'un plat végétarien (12 points) 175
Exercice 4.29 – Adapter une recette à un groupe aux pratiques variées (10 points) 177
Exercice 4.30 – Le Ramadan au centre de formation d'apprentis (16 points) 178
Corrigés de la partie 5 180
Partie 6 – Les rythmes alimentaires et les âges de la vie 183
Exercice 4.31 – Légender la répartition de l'énergie dans la journée (8 points) 184
Exercice 4.32 – La journée d'une étudiante en stage du matin (12 points) 185
Exercice 4.33 – Faut-il garder la collation de 10 h ? (12 points) 187
Exercice 4.34 – Trois petits-déjeuners de lycéens (12 points) 188
Exercice 4.35 – Les comportements selon les âges de la vie (10 points) 190

Exercice 4.36 – Le portage de repas à domicile (16 points) 191
Corrigés de la partie 6 193
Partie 7 – Le comportement alimentaire de l'enfant 196
Exercice 4.37 – Légender le développement du comportement alimentaire (8 points) 197
Exercice 4.38 – Légender le partage des responsabilités (10 points) 198
Exercice 4.39 – Faire accepter la courge à la cantine maternelle (12 points) 199
Exercice 4.40 – Ce que disent les parents à table (10 points) 200
Exercice 4.41 – Vrai ou faux sur la diversification (10 points) 202
Exercice 4.42 – Former les assistantes maternelles du relais petite enfance (16 points) 203
Corrigés de la partie 7 205
Partie 8 – Observer, mesurer et agir pour une alimentation durable 208
Exercice 4.43 – Légender les outils d'observation et choisir le bon (10 points) 209
Exercice 4.44 – Classer des produits selon NOVA (10 points) 211
Exercice 4.45 – L'empreinte carbone des menus d'un collège (14 points) 213
Exercice 4.46 – Une dégustation pour valider deux recettes (12 points) 215
Exercice 4.47 – La pesée des restes au self (12 points) 217
Exercice 4.48 – Cas complet : les repas à la maison d'enfants (40 points) 219
Corrigés de la partie 8 222
Bilan : grille d'auto-évaluation 226

Cahier d'exercices – Chapitre 4

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 4 : rôles de l'acte alimentaire, comportement alimentaire (besoin, envie, oralité, pulsion), régulation et dérégulations, déterminants, évolution des pratiques et syncrétisme culinaire, pratiques alimentaires actuelles et religieuses, rythmes alimentaires, comportements selon les âges, développement du comportement alimentaire de l'enfant, observation et mesure des comportements, alimentation durable (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition », C3.2 « Concevoir et réaliser des ateliers culinaires adaptés au public visé » et C3.5 « Communiquer et interagir dans un contexte d'intervention en santé » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : rôles de l'acte alimentaire, faim-rassasiement-satiété, systèmes de régulation, cercle de la restriction cognitive, déterminants, répartition de l'énergie dans la journée, développement du comportement alimentaire de l'enfant, partage des responsabilités, outils d'observation, classification NOVA, dimensions de l'alimentation durable.
- Calculer et interpréter : densité énergétique et composition d'un repas (Ciqual 2025), coût de 100 kcal, répartition de l'énergie, taux d'acceptation, empreinte carbone, échelle hédonique, pesée des restes.
- Proposer des actions qui respectent les pratiques du public, préservent le plaisir et ne culpabilisent pas.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits d'entretiens), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, prix et chiffres des enquêtes locales sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025) ; les auteurs, les textes officiels et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés.

Méthode – Analyser un comportement alimentaire à l'examen

Pour chaque situation, suivez trois temps : décrire le comportement (quoi, quand, combien, où, avec qui), l'expliquer avec une notion du cours (régulation, déterminant, rôle de l'acte alimentaire, pratique) en citant un élément précis du document, puis proposer une action qui part des pratiques réelles du public, préserve le plaisir et ne culpabilise pas. Un conseil qui ne vise que le rôle biologique (« mangez ceci, pas cela ») est rarement suivi et rapporte peu de points.

Partie 1 – Les rôles de l'acte alimentaire et le comportement alimentaire

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer et illustrer les six rôles de l'acte alimentaire.
- Définir le comportement alimentaire et distinguer besoin, envie, oralité et pulsion.
- Montrer qu'un message qui ne tient compte que du rôle biologique a peu de chances d'être suivi.
- Relier la place de l'alimentation dans le budget aux revenus des ménages.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Six rôles de l'acte alimentaire : biologique, hédonique, psychologique, social, culturel et identitaire, économique.
- Comportement alimentaire : ensemble des conduites d'un individu vis-à-vis de l'alimentation (choix, préparation, nombre et horaires des prises, quantités, lieux et conditions des repas, manière de manger). Il résulte de facteurs physiologiques, psychologiques et socioculturels.
- Besoin : nécessité physiologique d'apports en énergie, en eau et en nutriments, qui se traduit par la faim et la soif. Envie (appétit) : désir d'un aliment particulier, orienté par le plaisir, même sans faim.
- Oralité : ensemble des fonctions de la bouche (succion, déglutition, mastication, goût, langage) ; l'oralité alimentaire se construit de la vie fœtale à l'enfance. Pulsion : poussée interne, peu contrôlée, vers la prise alimentaire, souvent liée à une tension émotionnelle.
- Le « repas gastronomique des Français » est inscrit depuis 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité (UNESCO). La part de l'alimentation dans la consommation des ménages est passée de 35 % en 1960 à 20 % en 2014 (Insee, 2015).

Exercice 4.1 – Légender les rôles de l'acte alimentaire (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une intervention auprès de futurs animateurs de centres de loisirs. Vous voulez leur montrer que le goûter n'est pas seulement un apport d'énergie.

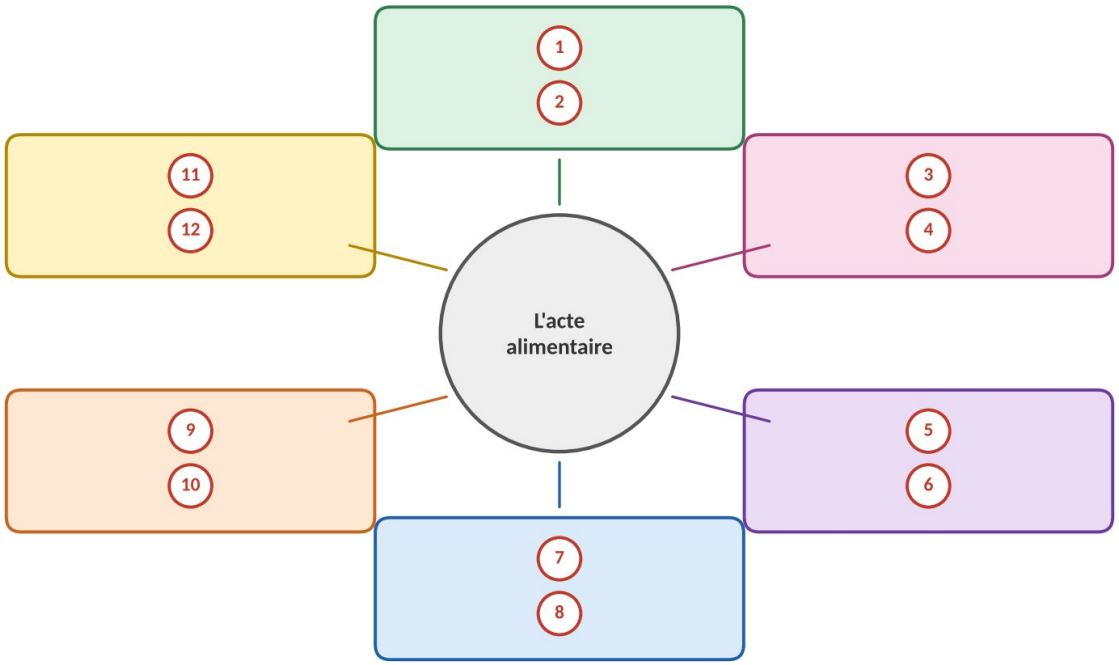


Figure 4.1 – Document 1 – Les rôles de l'acte alimentaire (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1 : le nom de chaque rôle et sa définition courte. (6 pts)
2. Pour le goûter au centre de loisirs, donnez un exemple concret de trois rôles différents. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.2 – Reconnaître les rôles dans la parole des résidents (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans une résidence autonomie pour personnes âgées. Pour préparer une animation « le repas, c'est la vie », vous avez noté des phrases dites par les résidents pendant le déjeuner.

Document 1 – Ce que disent les résidents

a) « Je viens au restaurant de la résidence surtout pour voir du monde. Seule chez moi, je ne mangeais plus. »

b) « Le dimanche, j'achète un petit gâteau à la pâtisserie. Je me fais plaisir, à mon âge on a le droit. »

c) « La soupe de ma mère, avec le lard et le chou, ça me rappelle la ferme. Quand je la sens, je me sens bien. »

d) « Je mange du poisson le vendredi, comme on a toujours fait chez nous. »

e) « Le médecin m'a dit de manger de la viande ou des œufs pour garder mes muscles. »

f) « Avec ma petite retraite, je regarde les prix. Le repas ici me coûte 7,20 €, je ne viens pas tous les jours. »

g) « Les jours de fête, on met une nappe et on mange ensemble jusqu'à 15 heures. »

h) « Quand je suis triste, je mange des carrés de chocolat. »

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque phrase du document 1 au rôle de l'acte alimentaire principal qu'elle illustre. Plusieurs phrases peuvent illustrer le même rôle. (4 pts)
2. Choisissez deux phrases qui illustrent deux rôles à la fois et justifiez. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi la phrase a) est un signal d'alerte pour la santé de cette résidente. (2 pts)
4. Proposez deux idées pour l'animation qui s'appuient sur des rôles autres que le rôle biologique. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.3 – Besoin, envie, oralité, pulsion (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une éducatrice d'un institut médico-éducatif (IME) qui accueille des enfants de 6 à 14 ans vous transmet des observations faites pendant les repas et les goûters.

Document 1 – Observations de l'éducatrice

a) Tom, 8 ans, réclame à manger à 11 h 30 après un petit-déjeuner léger ; il dit avoir « le ventre qui gargouille ».

b) Inès, 10 ans, demande des bonbons chaque fois qu'elle passe devant le distributeur du hall, même juste après le repas.

c) Yanis, 7 ans, ne supporte que les aliments mixés ; les morceaux lui donnent des haut-le-cœur.

d) Léo, 13 ans, après une dispute avec un camarade, avale très vite trois tranches de pain et un paquet de biscuits.

e) Sarah, 6 ans, boit beaucoup d'eau après la récréation par une chaude journée de juin.

f) Malo, 9 ans, a été prématuré et a été nourri par sonde pendant ses premières semaines ; il refuse de porter les aliments à la bouche.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez le comportement alimentaire. (2 pts)
2. Classez chaque observation : besoin (faim ou soif), envie, trouble de l'oralité, pulsion. (3 pts)
3. Expliquez la différence entre un besoin et une envie, en vous appuyant sur les situations a) et b). (1,5 pt)
4. Indiquez à qui l'éducatrice doit signaler les situations c) et f), et pourquoi le diététicien de santé publique ne les prend pas en charge seul. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.4 – Réécrire une affiche « 100 % biologique » (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de santé au travail d'une entreprise de logistique a affiché le document 1 dans la salle de pause. Le médecin du travail constate que l'affiche ne change rien aux habitudes et vous demande de la retravailler.

Document 1 – L'affiche actuelle

« ALIMENTATION : LES BONS GESTES. Votre corps a besoin de 2 000 kcal par jour. Les frites, la charcuterie et les sodas sont interdits. Mangez 5 fruits et légumes, du poisson 2 fois par semaine et des féculents complets. Une pause déjeuner de 10 minutes suffit si vous mangez sain. »

Document 2 – Ce que disent les salariés

« On mange ensemble au camion pizza le vendredi, c'est notre moment. » « Avec mes horaires, je n'ai pas le temps de cuisiner. » « Les fruits au distributeur coûtent plus cher que les barres. » « Quand j'ai fini une nuit difficile, j'ai besoin d'un truc sucré. » « Chez moi on mange de la semoule et des légumes, je ne vois pas ça sur l'affiche. »

À vous de jouer – Questions

1. Montrez que l'affiche ne tient compte que du rôle biologique de l'acte alimentaire. (2 pts)
2. Repérez dans le document 2 quatre autres rôles et citez la phrase correspondante. (4 pts)
3. Relevez deux formulations de l'affiche qui risquent de culpabiliser ou d'être contre-productives. (2 pts)
4. Rédigez une nouvelle accroche et trois messages courts qui tiennent compte d'au moins trois rôles. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.5 – La part de l'alimentation dans le budget (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre communal d'action sociale (CCAS) prépare un atelier « budget et alimentation ». La conseillère en économie sociale et familiale vous transmet les budgets mensuels de trois ménages qu'elle accompagne ou qu'elle a pris comme exemples.

Document 1 – Budgets mensuels de trois ménages (données fictives)

Ménage	Personnes	Dépenses de consommation par mois	Dépenses alimentaires à domicile par mois
A – Parent seul, un enfant	2	1 450 €	390 €
B – Couple, un enfant	3	2 900 €	520 €
C – Couple, deux enfants	4	5 600 €	780 €

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de l'alimentation dans les dépenses de chaque ménage (en %, une décimale). (3 pts)
2. Calculez la dépense alimentaire par personne et par mois pour chaque ménage. (1,5 pt)
3. Les prix alimentaires augmentent de 12 % sans que les autres dépenses changent. Calculez, pour les ménages A et C, la dépense supplémentaire par mois et ce qu'elle représente en pourcentage de leurs dépenses actuelles. (3 pts)
4. Interprétez ces résultats en vous appuyant sur la loi d'Engel (Ernst Engel, 1857) : plus le revenu est faible, plus la part consacrée à l'alimentation est élevée. (2,5 pts)
5. Indiquez deux conséquences pour l'atelier du CCAS. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.6 – Manger seul au foyer de jeunes travailleurs (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au foyer de jeunes travailleurs (FJT) « Les Hirondelles » (données fictives), qui loge 90 jeunes de 18 à 25 ans en apprentissage, en premier emploi ou en formation. Chaque studio a une plaque de cuisson et un petit réfrigérateur ; une grande cuisine collective, au rez-de-chaussée, est peu utilisée. La directrice s'inquiète : beaucoup de jeunes mangent seuls dans leur studio, certains sautent le repas du soir. Elle vous demande une analyse et des propositions.

Document 1 – Résultats du questionnaire (64 répondants sur 90, données fictives)

Question	Réponses « oui »
Je mange seul dans mon studio le soir au moins 5 soirs sur 7	41
Je saute le repas du soir au moins une fois par semaine	23
J'aimerais des repas partagés de temps en temps	38
Je sais cuisiner au moins cinq plats différents	19
Je commande un repas livré au moins une fois par semaine	27

Document 2 – Extraits d'entretiens

« Je rentre à 19 h 30, crevé, je mange des pâtes devant mon téléphone. » « Le dimanche soir, ma mère me prépare des boîtes, ça me fait la semaine… enfin trois jours. » « La cuisine en bas, je n'y vais pas, je ne connais personne. » « Quand c'est la fin du mois, je saute le dîner, je bois un café. » « J'aimerais apprendre à faire le mafé de ma grand-mère. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de réponse, puis le pourcentage de « oui » pour chaque question du document 1 (base : répondants). (3 pts)
2. Analysez la situation à l'aide de quatre rôles de l'acte alimentaire, en citant le document 2. (4 pts)
3. Identifiez deux facteurs qui expliquent le saut du repas du soir. (2 pts)
4. Proposez trois actions qui utilisent la cuisine collective ; pour chacune, indiquez le rôle de l'acte alimentaire visé. (4,5 pts)
5. Proposez deux indicateurs d'évaluation. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 4.1

1. Légendes : 1 Biologique ; 2 couvrir les besoins en énergie, en eau et en nutriments ; 3 Hédonique ; 4 procurer du plaisir : goût, odeur, texture ; 5 Psychologique ; 6 réconfort, sécurité affective, souvenirs ; 7 Social ; 8 partager, créer du lien, structurer le temps ; 9 Culturel et identitaire ; 10 dire qui l'on est et à quel groupe on appartient ; 11 Économique ; 12 budget des ménages, production, emploi.
2. Exemples : rôle biologique, le goûter couvre la faim de 16 h 30 chez des enfants qui ont un long écart entre le déjeuner et le dîner ; rôle social, les enfants goûtent ensemble, assis, et partagent le gâteau préparé par l'atelier cuisine ; rôle hédonique, on choisit un goûter que les enfants aiment (pain et chocolat, fruit de saison) ; rôle culturel, on fait goûter les gâteaux des fêtes de différentes familles ; rôle économique, le centre achète un goûter qui tient dans un budget de 0,60 € par enfant.

Corrigé – Exercice 4.2

1. a) social ; b) hédonique ; c) psychologique (souvenir, réconfort) ; d) culturel et identitaire (tradition religieuse et familiale) ; e) biologique (besoins en protéines pour la masse musculaire) ; f) économique ; g) social (fête, convivialité, temps partagé) ; h) psychologique (gestion des émotions).
2. Exemples : c) est à la fois psychologique et culturel (la soupe de la ferme rattache la résidente à son origine régionale) ; g) est social et culturel (manières de table, nappe, rituel du repas de fête) ; b) est hédonique et psychologique (« on a le droit » : estime de soi, récompense).
3. Seule, elle « ne mangeait plus » : l'isolement est un facteur de risque de dénutrition chez la personne âgée. Le repas partagé stimule l'appétit (facilitation sociale) ; si elle ne vient pas au restaurant, elle risque de manger trop peu, de perdre du poids et de la force musculaire.
4. Exemples : un atelier « soupes d'autrefois » où chaque résident apporte sa recette et raconte son souvenir (rôles psychologique et culturel) ; un repas à thème mensuel préparé avec les résidents, avec une nappe et de la musique (rôles social et hédonique) ; un « café-gourmand » d'accueil des nouveaux résidents (rôle social).

Corrigé – Exercice 4.3

1. Le comportement alimentaire est l'ensemble des conduites d'une personne vis-à-vis de l'alimentation : ce qu'elle choisit, comment elle prépare, combien de fois et à quelle heure elle mange, quelles quantités, où, avec qui et de quelle manière. Il dépend de facteurs physiologiques (faim, satiété), psychologiques (émotions, apprentissages) et socioculturels (habitudes, normes, environnement).
2. a) besoin (faim, signal corporel) ; b) envie (désir provoqué par la vue du distributeur, sans faim) ; c) trouble de l'oralité (difficulté à accepter les morceaux) ; d) pulsion (prise rapide et peu contrôlée, liée à une tension émotionnelle) ; e) besoin (soif) ; f) trouble de l'oralité (lié à la prématurité et à l'alimentation par sonde).
3. Tom ressent un signal physiologique (ventre qui gargouille, petit-déjeuner léger) : c'est un besoin, il s'apaise avec n'importe quel aliment. Inès désire un aliment précis, déclenché par un signal extérieur (le distributeur), même sans faim : c'est une envie, orientée par le plaisir.
4. Au médecin de l'IME et à la famille, qui pourront orienter vers une prise en charge spécialisée (orthophoniste formé à l'oralité, psychomotricien, équipe médicale). Les troubles de l'oralité relèvent du soin individuel et pluridisciplinaire ; le diététicien de santé publique repère et oriente, il ne diagnostique pas et ne traite pas.

Corrigé – Exercice 4.4

1. L'affiche parle de besoins chiffrés (2 000 kcal), d'aliments à éviter et d'aliments à consommer : elle ne considère l'alimentation que comme un apport d'énergie et de nutriments. Elle ignore le plaisir, le lien

social, les émotions, la culture et le budget.

2. Rôle social : « On mange ensemble au camion pizza le vendredi, c'est notre moment. » Rôle économique : « Les fruits au distributeur coûtent plus cher que les barres. » Rôle psychologique : « Quand j'ai fini une nuit difficile, j'ai besoin d'un truc sucré. » Rôle culturel et identitaire : « Chez moi on mange de la semoule et des légumes, je ne vois pas ça sur l'affiche. » On peut ajouter le temps disponible (« je n'ai pas le temps de cuisiner »), qui est une contrainte de l'environnement.

3. « Les frites, la charcuterie et les sodas sont interdits » : l'interdit crée de la frustration et renforce l'attrait des aliments interdits (restriction cognitive) ; il culpabilise ceux qui en mangent. « Une pause de 10 minutes suffit si vous mangez sain » : manger vite empêche le rassasiement de s'installer ; le message dévalorise aussi le repas partagé. Le chiffre de 2 000 kcal est une moyenne qui ne correspond pas à chacun.

4. Exemple d'accroche : « Bien manger au travail, c'est aussi se faire plaisir ensemble. » Messages : « Le vendredi pizza ? Gardez ce moment, ajoutez une salade à partager. » ; « Couscous, tajine, pot-au-feu : les plats de légumes de chez vous comptent aussi. » ; « Une pause de 30 minutes assis, c'est mieux pour la digestion et pour l'équipe. » On peut aussi demander à l'entreprise de mettre des fruits au prix des barres.

Corrigé – Exercice 4.5

1. A : 390 / 1 450 × 100 = 26,9 %. B : 520 / 2 900 × 100 = 17,9 %. C : 780 / 5 600 × 100 = 13,9 %.

2. A : 390 / 2 = 195,00 € par personne. B : 520 / 3 = 173,33 €. C : 780 / 4 = 195,00 €.

3. A : 390 × 0,12 = 46,80 € de plus par mois, soit 46,80 / 1 450 × 100 = 3,2 % de ses dépenses. C : 780 × 0,12 = 93,60 € de plus, soit 93,60 / 5 600 × 100 = 1,7 % de ses dépenses.

4. Le ménage A, aux dépenses les plus faibles, consacre la plus grande part à l'alimentation (26,9 % contre 13,9 % pour C) ; c'est ce que décrit la loi d'Engel. Par personne, A dépense autant que C (195 €), mais cela lui coûte presque deux fois plus de son budget. Une hausse des prix pèse donc beaucoup plus sur A (3,2 % de son budget) que sur C (1,7 %) : l'alimentation devient une variable d'ajustement, on réduit la qualité pour garder la quantité.

5. L'atelier ne doit pas faire la morale sur les achats ; il valorise les compétences de gestion des familles et propose des recettes à petit prix (légumes secs, produits de saison, cuisine des restes). Il faut aussi informer sur les aides (épicerie solidaire, chèques alimentaires) et éviter de conseiller des produits chers (labels, bio) comme seule voie vers une alimentation saine.

Corrigé – Exercice 4.6

1. Taux de réponse : 64 / 90 × 100 = 71,1 %. Mange seul au moins 5 soirs sur 7 : 41 / 64 × 100 = 64,1 % ; saute le dîner au moins une fois par semaine : 23 / 64 = 35,9 % ; aimerait des repas partagés : 38 / 64 = 59,4 % ; sait cuisiner au moins cinq plats : 19 / 64 = 29,7 % ; commande un repas livré au moins une fois par semaine : 27 / 64 = 42,2 %.

2. Rôle social : le repas est pris seul (64,1 %), devant le téléphone ; la cuisine collective n'est pas utilisée car « je ne connais personne » ; pourtant 59,4 % souhaitent des repas partagés. Rôle psychologique et affectif : les boîtes préparées par la mère rassurent et prolongent le lien familial. Rôle culturel et identitaire : le souhait d'apprendre « le mafé de ma grand-mère » montre l'envie de transmettre une identité familiale. Rôle économique : à la fin du mois, le dîner est sauté et remplacé par un café ; la livraison (42,2 %) pèse aussi sur le budget. Rôle biologique : le saut du dîner et les repas de pâtes seules risquent de ne pas couvrir les besoins de jeunes actifs.

3. Le budget (fin de mois difficile) et le manque de compétences culinaires (seuls 29,7 % savent cuisiner cinq plats), auxquels s'ajoutent la fatigue après le travail et l'isolement (manger seul motive peu à cuisiner).

4. Exemples : un « dîner partagé » mensuel préparé ensemble dans la cuisine collective, chacun apportant un ingrédient (rôle social) ; un atelier « recettes de nos familles » où un jeune montre le mafé de sa grand-mère aux autres (rôle culturel et identitaire, valorisation) ; un atelier « cuisiner pour 4 soirs avec 10 € »

qui apprend à préparer à l'avance et à congeler (rôle économique et biologique) ; un « placard solidaire » de produits de base dans la cuisine collective (rôle économique).

5. Processus : nombre de participants à chaque dîner partagé et à chaque atelier ; nombre d'utilisations de la cuisine collective par semaine (cahier de réservation). Résultats : à un an, même questionnaire : part des jeunes qui sautent le dîner au moins une fois par semaine (objectif : passer de 35,9 % à moins de 25 %), part de ceux qui savent cuisiner cinq plats.

Partie 2 – La régulation du comportement alimentaire

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir et situer dans le temps la faim, le rassasiement et la satiété, avec leurs principaux signaux.
- Expliquer l'équilibre entre régulation homéostatique, régulation hédonique, facteurs cognitifs et facteurs environnementaux.
- Utiliser le rassasiement sensoriel spécifique, la taille des portions et la densité énergétique pour concevoir des actions.
- Calculer et interpréter la densité énergétique d'un repas à partir de la table Ciqual 2025.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Faim (avant le repas) : sensation qui pousse à manger ; ghréline sécrétée par l'estomac. Rassasiement (pendant) : processus qui conduit à arrêter de manger ; distension gastrique, cholécystokinine (CCK), baisse du plaisir pour l'aliment consommé. Satiété (après) : absence de faim jusqu'au repas suivant ; GLP-1, PYY, insuline, et leptine à long terme.
- Cascade de satiété (Blundell, 1987) : succession de signaux sensoriels, cognitifs, post-ingestifs et post-absorptifs.
- Rassasiement sensoriel spécifique (Rolls et coll., 1981) : le plaisir diminue pour l'aliment que l'on mange, mais reste intact pour un autre aliment ; la variété augmente la quantité consommée.
- Régulation homéostatique (hypothalamus, « manger pour vivre ») et régulation hédonique (système de la récompense, dopamine) ; elles sont influencées par des facteurs cognitifs (règles, attention) et environnementaux (portions, écrans, convives, émotions).
- Densité énergétique : énergie apportée par 100 g d'aliment ou de repas (kcal pour 100 g). Les aliments riches en eau et en fibres (légumes, fruits, soupes) ont une faible densité énergétique et rassasient pour peu de calories.

Exercice 4.7 – Légender faim, rassasiement et satiété (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une séance d'éducation pour un groupe de collégiens de 4e sur le thème « écouter son corps ». Vous projetez le schéma du document 1.

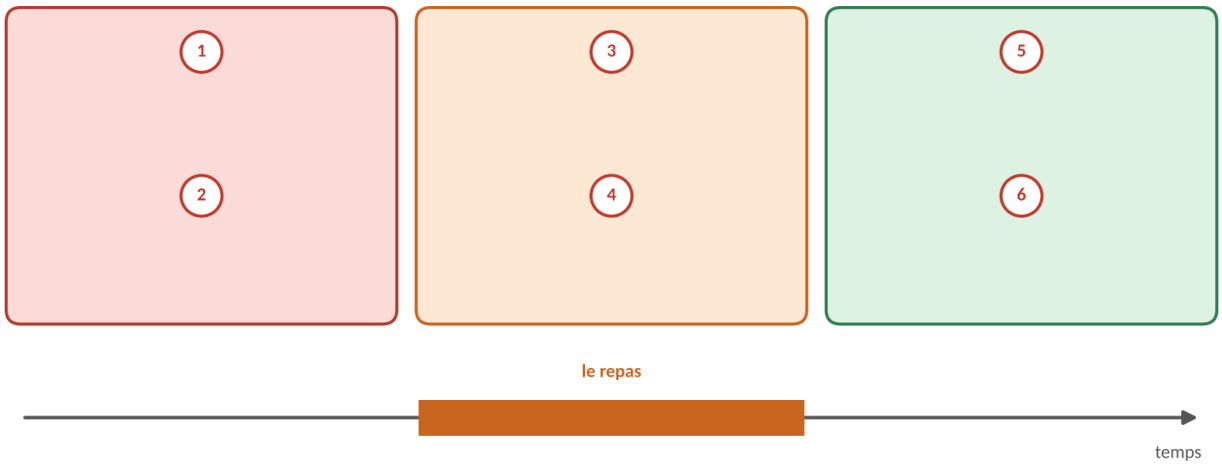


Figure 4.2 – Document 1 – Faim, rassasiement et satiété (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1 : le nom de chaque étape, puis le moment et les signaux en jeu. (4,5 pts)
2. Donnez deux conseils pratiques qui favorisent le rassasiement et la satiété. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi une boisson sucrée rassasie peu. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.8 – Légender les systèmes de régulation (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une maison de santé pluriprofessionnelle, vous animez une réunion d'information pour les infirmières sur « pourquoi on mange plus qu'on ne voudrait ».

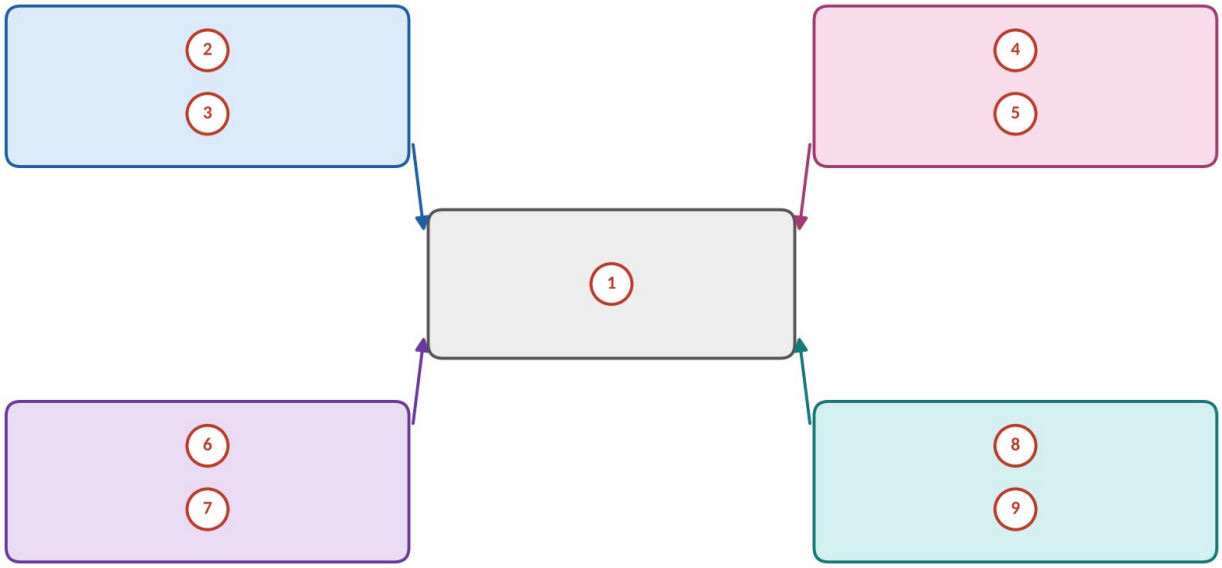


Figure 4.3 – Document 1 – Les systèmes de régulation de la prise alimentaire (schéma à légender)

Document 2 – Situations rapportées par les infirmières

a) Une patiente dit : « Je ne mange jamais après 18 h, c'est ma règle, même si j'ai faim. »

b) Un patient mange tout son paquet de chips devant un match, sans s'en rendre compte.

c) Un enfant qui a couru tout l'après-midi réclame un deuxième morceau de pain au goûter.

d) Au restaurant, une patiente commande un dessert au chocolat alors qu'elle n'a plus faim.

e) Un patient se ressert parce que le plat est sur la table et que tout le monde se ressert.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)
2. Associez chaque situation du document 2 au système ou au facteur qui domine. (2,5 pts)
3. Expliquez pourquoi, dans un environnement d'abondance, les signaux internes de satiété sont souvent dépassés. (2 pts)
4. Proposez une phrase simple que les infirmières peuvent dire à un patient pour expliquer ce schéma sans le culpabiliser. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.9 – Manger vite, manger lentement (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – calcul guidé · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier « faim et plaisir » organisé par une mutuelle, dix adultes volontaires mangent deux fois le même repas, à une semaine d'intervalle. La première semaine, le repas dure 8 minutes (consigne : manger comme d'habitude, au travail). La deuxième semaine, il dure 20 minutes (consigne : poser les couverts entre deux bouchées, décrire le goût). À la fin de chaque repas, chacun note son rassasiement sur une échelle de 0 (pas du tout rassasié) à 10 (très rassasié) et dit s'il aurait envie de se resservir.

Document 1 – Résultats (données fictives)

Participant	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rassasiement, repas en 8 min	5	6	4	7	5	6	5	4	6	5
Rassasiement, repas en 20 min	7	8	6	8	7	7	6	7	8	7
Envie de se resservir (8 min)	oui	oui	oui	non	oui	non	oui	oui	non	non
Envie de se resservir (20 min)	non	non	oui	non	non	non	oui	non	non	non

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le score moyen de rassasiement pour chaque repas et l'écart entre les deux. (3 pts)

2. Calculez le pourcentage de participants qui auraient envie de se resservir après chaque repas. (2 pts)

3. Expliquez ces résultats à l'aide du rassasiement et des signaux qui le provoquent. (2 pts)

4. Citez trois limites de cette expérience. (2 pts)

5. Proposez un message à retenir pour les participants. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.10 – Le rassasiement sensoriel spécifique au buffet (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une résidence universitaire teste deux formules de dîner. Formule 1 : un plat unique de pâtes à la sauce tomate, à volonté. Formule 2 : les mêmes pâtes, avec trois sauces différentes et trois légumes, à volonté. Vingt étudiants volontaires ont mangé les deux formules à deux soirs différents. Le gestionnaire voudrait savoir s'il doit généraliser la formule 2.

Document 1 – Résultats moyens (données fictives)

Mesure	Formule 1 (un seul plat)	Formule 2 (plat varié)
Énergie consommée au plat principal	640 kcal	830 kcal
Plaisir pour les pâtes avant le repas (sur 10)	7,2	7,2
Plaisir pour les pâtes à la fin du plat (sur 10)	3,9	5,8
Plaisir pour le dessert (yaourt aux fruits), à la fin du plat (sur 10)	7,0	6,8
Légumes consommés	0 g	145 g

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'augmentation de l'énergie consommée avec la formule 2, en kcal et en %. (2 pts)
2. Calculez la baisse du plaisir pour les pâtes dans chaque formule, en points et en %. (2 pts)
3. Expliquez ces résultats à l'aide du rassasiement sensoriel spécifique (Rolls et coll., 1981). Expliquez aussi pourquoi le dessert garde son attrait. (3 pts)
4. Montrez que ce mécanisme peut être utilisé de façon positive pour faire manger plus de légumes. Proposez une formule qui garde la variété des légumes sans multiplier les sauces. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.11 – La taille des portions au self (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un restaurant d'entreprise sert le même plat de pâtes à deux groupes comparables de 40 salariés, deux jours différents. Le premier jour, la portion servie est de 250 g de pâtes cuites ; le deuxième jour, de 400 g. On pèse ce qui reste dans l'assiette et on demande aux salariés, deux heures après, d'évaluer leur satiété sur 10.

Document 1 – Résultats moyens par personne (données fictives) et donnée Ciqual

Mesure	Portion de 250 g	Portion de 400 g
Pâtes consommées	230 g	330 g
Satiété deux heures après (sur 10)	7,1	7,4

Pâtes sèches standard, cuites, sans sel ajouté : 167 kcal pour 100 g (Ciqual 2025, code 9811).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie apportée par les pâtes consommées dans chaque cas, puis l'écart en kcal et en %. (3 pts)
2. Calculez les restes par personne (en g et en % de la portion servie). (2 pts)
3. Comparez l'augmentation de la quantité mangée et celle de la satiété. Concluez sur l'effet de la taille des portions. (2 pts)
4. Si un salarié mange cette grande portion 5 jours par semaine, calculez l'énergie supplémentaire par semaine. (1 pt)
5. Proposez trois aménagements du self qui respectent la régulation sans priver les salariés. (3 pts)
6. Indiquez pourquoi on n'a pas comparé les mêmes salariés les deux jours, et ce que cela change. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.12 – Deux déjeuners, deux densités énergétiques (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous intervenez dans un centre d'appels où les salariés déjeunent à l'espace de restauration d'un centre commercial voisin. Beaucoup se plaignent d'avoir « un coup de barre » à 15 h et de grignoter en fin d'après-midi. Vous comparez deux déjeuners souvent choisis.

Document 1 – Composition des deux déjeuners et valeurs Ciqual 2025 pour 100 g

Menu	Aliment (code Ciqual)	Quantité	Énergie (kcal pour 100 g)	Lipides (g pour 100 g)
A	Sandwich kebab, baguette, crudités (25429)	300 g	272	9,8
A	Frites surgelées cuites en friteuse (4032)	150 g	258	11,9
A	Cola sucré (18018)	330 g	40,1	0
B	Filet de poulet grillé (36018)	120 g	141	2
B	Riz complet cuit (9103)	200 g	187	1,8
B	Haricots verts cuits (20030)	150 g	29,4	0,17
B	Huile de colza (17130)	5 g	900	100
B	Yaourt nature (19593)	125 g	50,1	1,68
B	Pomme crue (13039)	150 g	54	0,25

Document 2 – Autres apports calculés avec Ciqual 2025

Apport	Menu A	Menu B
Protéines	49,9 g	52,0 g
Fibres	11,9 g	12,3 g
Sel	3,5 g	1,0 g
Sucres	43,8 g	21,2 g

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie de chaque menu (une décimale). (3 pts)
2. Calculez la masse totale de chaque menu, puis sa densité énergétique en kcal pour 100 g. Pour le menu A, calculez aussi la densité sans la boisson. (3 pts)
3. Calculez la quantité de lipides de chaque menu et la part de l'énergie qu'ils apportent (1 g de lipides = 9 kcal). (2 pts)
4. Comparez les deux menus à l'aide des documents 1 et 2 : qu'ont-ils en commun, qu'est-ce qui les sépare ? (3 pts)
5. Expliquez le lien possible entre le menu A et le « coup de barre » puis le grignotage, sans affirmer plus que ce que les données permettent. (2 pts)
6. Proposez trois conseils réalistes pour les salariés qui veulent garder leur kebab du vendredi. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 4.7

1. Légendes : 1 Faim ; 2 avant le repas : sensation qui pousse à manger ; ghréline sécrétée par l'estomac ; 3 Rassasiement ; 4 pendant le repas : processus qui conduit à arrêter de manger ; distension de l'estomac, CCK ; 5 Satiété ; 6 après le repas : absence de faim jusqu'au repas suivant ; GLP-1, PYY, insuline, leptine.
2. Manger lentement, assis, sans écran, en posant ses couverts entre deux bouchées (les signaux du rassasiement mettent une vingtaine de minutes à s'installer) ; choisir des aliments riches en fibres et en protéines (légumes, légumes secs, pain complet, produits laitiers), qui favorisent la satiété.
3. Le sucre liquide passe vite, sans mastication, et ne distend presque pas l'estomac ; les signaux de rassasiement sont faibles. L'énergie apportée par une boisson sucrée n'est pas « compensée » par une baisse de ce que l'on mange ensuite.

Corrigé – Exercice 4.8

1. Légendes : 1 Prise alimentaire : quoi, quand, combien ; 2 Régulation homéostatique ; 3 l'hypothalamus maintient l'équilibre énergétique ; 4 Régulation hédonique ; 5 le système de la récompense pousse à manger pour le plaisir ; 6 Facteurs cognitifs ; 7 règles, connaissances, attention, restriction ; 8 Facteurs environnementaux ; 9 portions, disponibilité, écrans, émotions, convives.
2. a) facteurs cognitifs (règle qui l'emporte sur la faim) ; b) facteurs environnementaux (écran, attention détournée) ; c) régulation homéostatique (vraie faim après une dépense d'énergie) ; d) régulation hédonique (plaisir sans faim) ; e) facteurs environnementaux (disponibilité du plat et influence des convives).
3. Les aliments très gras et sucrés, bon marché et disponibles partout, activent fortement le système de la récompense ; les grandes portions, les écrans et les sollicitations publicitaires détournent l'attention des signaux internes. Les signaux de satiété, plus discrets et plus lents, sont alors « couverts » par les signaux hédoniques et environnementaux.
4. « Notre corps sait dire quand il a faim et quand il en a assez, mais autour de nous, beaucoup de choses nous poussent à manger plus : ce n'est pas un manque de volonté. »

Corrigé – Exercice 4.9

1. Repas en 8 min : 5 + 6 + 4 + 7 + 5 + 6 + 5 + 4 + 6 + 5 = 53 ; moyenne 53 / 10 = 5,3. Repas en 20 min : 7 + 8 + 6 + 8 + 7 + 7 + 6 + 7 + 8 + 7 = 71 ; moyenne 7,1. Écart : 7,1 − 5,3 = 1,8 point.
2. Après le repas en 8 min : 6 « oui » sur 10, soit 60 % ; après le repas en 20 min : 2 sur 10, soit 20 %.
3. Le rassasiement est un processus qui se construit pendant le repas : distension de l'estomac, hormones intestinales (CCK), signaux sensoriels. Il faut du temps pour que ces signaux arrivent au cerveau ; en 8 minutes, le repas est fini avant que le rassasiement ne soit complet, d'où l'envie de se resservir. L'attention portée au goût renforce aussi les signaux sensoriels.
4. Très petit échantillon (10 volontaires motivés) ; ordre des repas toujours le même (la deuxième semaine, les participants savaient ce qu'on attendait d'eux : effet d'attente et désirabilité sociale) ; mesure déclarative ; pas de mesure de ce qui a été mangé ensuite dans la journée ; conditions différentes (au travail, puis en atelier).
5. « Prendre 20 minutes pour manger, c'est laisser à son corps le temps de dire "stop". »

Corrigé – Exercice 4.10

1. 830 − 640 = 190 kcal de plus ; 190 / 640 × 100 = 29,7 % d'augmentation.
2. Formule 1 : 7,2 − 3,9 = 3,3 points, soit 3,3 / 7,2 × 100 = 45,8 % de baisse. Formule 2 : 7,2 − 5,8 = 1,4 point, soit 1,4 / 7,2 × 100 = 19,4 % de baisse.

3. Quand on mange toujours le même aliment, le plaisir qu'il procure diminue (rassasiement sensoriel spécifique) ; avec un plat unique, il chute de 45,8 % et l'on arrête de manger plus tôt. Avec trois sauces et trois légumes, chaque changement de goût « relance » le plaisir ; on mange donc davantage (29,7 % d'énergie en plus). Le dessert, d'un goût et d'une texture différents, n'a pas été « rassasié » : son attrait reste presque intact (7,0 et 6,8). C'est pourquoi on a souvent « encore de la place pour le dessert ».

4. La variété augmente la consommation de l'aliment que l'on varie. Si l'on varie les légumes plutôt que les sauces, on fait manger plus de légumes (145 g dans la formule 2 contre 0 g). Exemple de formule : les pâtes avec une seule sauce tomate, accompagnées d'un bar à trois légumes de couleurs différentes (carottes râpées, courgettes rôties, haricots verts), servi en premier ; la variété porte sur les aliments de faible densité énergétique, pas sur les sauces grasses.

Corrigé – Exercice 4.11

1. Portion de 250 g : 230 × 167 / 100 = 384,1 kcal. Portion de 400 g : 330 × 167 / 100 = 551,1 kcal. Écart : 551,1 − 384,1 = 167,0 kcal, soit 167,0 / 384,1 × 100 = 43,5 % de plus.

2. Portion de 250 g : 250 − 230 = 20 g de restes, soit 20 / 250 × 100 = 8,0 %. Portion de 400 g : 400 − 330 = 70 g, soit 70 / 400 × 100 = 17,5 %.

3. Les salariés mangent 43,5 % de plus avec la grande portion, mais leur satiété n'augmente que de 0,3 point sur 10 (7,1 contre 7,4). La taille de la portion influence la quantité mangée bien plus que les besoins ressentis : c'est un facteur environnemental. Ces résultats vont dans le sens des expériences de l'équipe de Barbara Rolls (2002), où une portion plus grande augmentait la consommation sans augmenter la satiété.

4. 167,0 × 5 = 835 kcal de plus par semaine.

5. Servir une portion moyenne et permettre de se resservir à la demande ; proposer deux tailles de portion au même prix au kilo (« petite faim », « grande faim ») ; utiliser des assiettes de taille raisonnable ; mettre en avant le bar à légumes avant les féculents. On ne supprime rien, on modifie le contexte.

6. Les deux groupes sont différents : leurs besoins et leurs habitudes peuvent différer (âge, sexe, activité physique). Comparer les mêmes personnes aurait éliminé ces différences, mais elles auraient pu se souvenir de la portion de la première fois. La conclusion reste donc prudente.

Corrigé – Exercice 4.12

1. Menu A : kebab 300 × 272 / 100 = 816,0 kcal ; frites 150 × 258 / 100 = 387,0 kcal ; cola 330 × 40,1 / 100 = 132,3 kcal ; total 816,0 + 387,0 + 132,3 = 1 335,3 kcal. Menu B : poulet 120 × 141 / 100 = 169,2 ; riz 200 × 187 / 100 = 374,0 ; haricots 150 × 29,4 / 100 = 44,1 ; huile 5 × 900 / 100 = 45,0 ; yaourt 125 × 50,1 / 100 = 62,6 ; pomme 150 × 54 / 100 = 81,0 ; total 775,9 kcal.

2. Menu A : 300 + 150 + 330 = 780 g ; densité 1 335,3 / 780 × 100 = 171,2 kcal pour 100 g ; sans la boisson : (1 335,3 − 132,3) / 450 × 100 = 1 203,0 / 450 × 100 = 267,3 kcal pour 100 g. Menu B : 120 + 200 + 150 + 5 + 125 + 150 = 750 g ; densité 775,9 / 750 × 100 = 103,5 kcal pour 100 g.

3. Menu A : 300 × 9,8 / 100 + 150 × 11,9 / 100 = 29,40 + 17,85 = 47,25 g, soit 47,25 × 9 / 1 335,3 × 100 = 31,8 % de l'énergie. Menu B : 2,40 + 3,60 + 0,26 + 5,00 + 2,10 + 0,38 = 13,73 g (arrondi 13,7 g), soit 13,73 × 9 / 775,9 × 100 = 15,9 % de l'énergie.

4. Points communs : des quantités voisines de protéines (49,9 et 52,0 g) et de fibres (11,9 et 12,3 g), grâce aux crudités du kebab et aux frites. Différences : le menu A apporte 1 335,3 / 775,9 = 1,72 fois plus d'énergie (559 kcal de plus) pour une masse presque identique (780 g contre 750 g) : sa densité énergétique est 1,65 fois plus élevée. Il apporte aussi 3,4 fois plus de lipides, 3,5 fois plus de sel et deux fois plus de sucres, dont 33 g dans le cola.

5. Un repas copieux, gras et accompagné de sucre liquide peut favoriser une somnolence en début d'après-midi (digestion longue), mais le « coup de barre » de 15 h dépend aussi du rythme biologique et du sommeil. Le grignotage de fin d'après-midi peut relever de l'habitude, de l'ennui ou du stress du centre d'appels plutôt que de la faim. Les données décrivent les menus, pas leur effet sur ces salariés : il faudrait

les interroger.

6. Prendre l'eau ou une boisson sans sucres à la place du cola (132 kcal et 33 g de sucres en moins) ; partager les frites ou prendre une petite portion, ou remplacer par une salade ; manger assis, en 20 minutes, avec les collègues ; ajouter un fruit dans l'après-midi comme collation prévue plutôt que de grignoter. Le kebab du vendredi garde sa place de moment convivial.

Partie 3 – Les dérégulations : restriction, émotions, troubles du comportement alimentaire

Objectifs – Objectifs de la partie

- Expliquer le cercle vicieux de la restriction cognitive (Herman et Polivy, 1975) et l'effet de désinhibition.
- Reconnaître l'alimentation émotionnelle, l'externalité, le grignotage et la compulsion.
- Situer les troubles du comportement alimentaire (TCA) : ordres de grandeur, facteurs de risque et de protection, rôle du diététicien (prévenir, repérer, orienter).
- Analyser un message « minceur » et proposer un message de prévention non stigmatisant.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Restriction cognitive (Herman et Polivy, 1975) : intention de contrôler son alimentation par des règles mentales plutôt que par les sensations, pour maigrir ou ne pas grossir. Elle entraîne frustration, perte de contrôle (désinhibition), culpabilité et reprise de poids.
- Alimentation émotionnelle : manger en réponse à une émotion. Externalité (Schachter, 1968) : manger en réponse à des signaux extérieurs (vue, odeur, heure, portion). Grignotage : prises répétées, hors repas, sans faim. Compulsion : envie irrésistible d'un aliment, prise rapide, culpabilité.
- TCA (DSM-5, 2013) : anorexie mentale, boulimie, hyperphagie boulimique, ARFID. Prévalences vie entière (Hudson et coll., 2007) : anorexie environ 0,9 % des femmes et 0,3 % des hommes ; boulimie 1,5 % et 0,5 % ; hyperphagie boulimique 3,5 % et 2 %.
- Recommandations de la HAS : anorexie mentale (2010), boulimie et hyperphagie boulimique (2019). En santé publique, le diététicien ne diagnostique pas : il prévient, repère et oriente (médecin, structures spécialisées, annuaire de la Fédération française anorexie boulimie).
- Une action « contre l'obésité » mal conçue peut favoriser les TCA (pesées publiques, objectifs de perte de poids chez les adolescents).

Exercice 4.13 – Légender le cercle de la restriction cognitive (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une salle de sport municipale vous demande d'intervenir auprès de ses adhérents, nombreux à suivre des « programmes minceur » trouvés sur internet. Vous voulez expliquer pourquoi les régimes restrictifs échouent souvent.

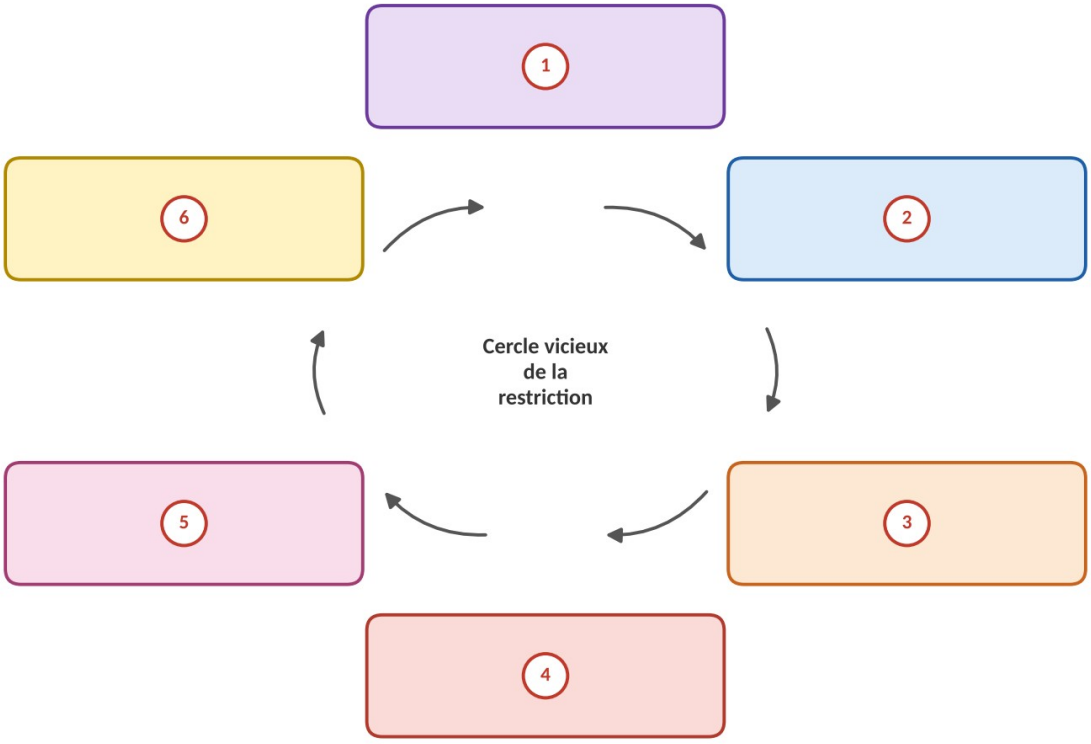


Figure 4.4 – Document 1 – Le cercle vicieux de la restriction cognitive (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1, dans l'ordre du cycle. (3 pts)
2. Définissez la restriction cognitive en citant les auteurs et l'année. (2 pts)
3. Indiquez à quelle étape du cycle il est le plus utile d'agir en prévention et proposez deux messages. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.14 – Nommer le phénomène (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un groupe de parole organisé par une association de patients diabétiques de type 2, vous avez noté les phrases suivantes. Vous voulez les utiliser pour construire une séance sur « manger avec ses sensations ».

Document 1 – Phrases notées pendant le groupe de parole

a) « À midi pile, je mange, même si je n'ai pas faim : c'est l'heure. »

b) « Le soir, devant la télévision, je pioche dans le placard sans m'en rendre compte. »

c) « Depuis le diagnostic, je me suis interdit le pain. Et puis un jour j'ai mangé une baguette entière. »

d) « Quand je me dispute avec mon fils, j'ai besoin de manger du fromage. »

e) « J'ai une envie terrible de chocolat, il me le faut tout de suite, je mange la tablette en cinq minutes et après je m'en veux. »

f) « Au restaurant, j'étais calé après le plat, mais j'ai quand même pris le fromage, puis le dessert. »

g) « Quand je vois les pâtisseries dans la vitrine, je ne peux pas passer devant sans entrer. »

h) « J'ai faim vers 16 h 30 ; je prends une pomme et un morceau de pain. »

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le phénomène illustré par chaque phrase : externalité, grignotage, restriction cognitive et désinhibition, alimentation émotionnelle, compulsion, rassasiement sensoriel spécifique, faim et collation prévue. Un même phénomène peut revenir. (4 pts)
2. Expliquez pourquoi la phrase c) est fréquente chez les personnes qui viennent d'apprendre une maladie chronique. (2 pts)
3. Indiquez la phrase qui montre un comportement adapté, et pourquoi. (1 pt)
4. Proposez trois exercices pour la séance « manger avec ses sensations ». (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.15 – Coter un questionnaire sur les règles alimentaires (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une infirmière de santé universitaire a construit, pour un atelier, un court questionnaire d'auto-observation inspiré des questionnaires de recherche (il n'est pas validé et ne sert pas à poser un diagnostic). Chaque phrase est notée de 1 (jamais) à 4 (presque toujours). Elle vous demande de l'aider à interpréter les réponses de quatre étudiants volontaires, qui ont accepté de les partager.

Document 1 – Les phrases du questionnaire (construites pour l'entraînement)

- Q1. Je compte les calories de ce que je mange.
- Q2. Je m'interdis certains aliments pour ne pas grossir.
- Q3. Je mange moins que ce dont j'ai envie pour contrôler mon poids.
- Q4. Après un « écart », je saute le repas suivant.
- Q5. Quand j'ai commencé à manger un aliment que je m'interdis, j'ai du mal à m'arrêter.
- Q6. Je mange quand je suis stressé ou triste.

Document 2 – Réponses de quatre étudiants (données fictives)

Étudiant	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
Alix	4	4	3	4	4	2
Bilal	1	1	2	1	1	1
Chloé	2	3	3	2	3	4
Dorian	1	2	1	1	2	3

À vous de jouer – Questions

1. Le score de « règles » est la somme de Q1 à Q4 (de 4 à 16). Calculez-le pour chaque étudiant. (2 pts)
2. Calculez la moyenne des quatre étudiants pour Q5 et pour Q6. (1 pt)
3. Décrivez le profil de chaque étudiant en utilisant les notions du cours : restriction cognitive, désinhibition, alimentation émotionnelle. (4 pts)
4. Indiquez la conduite à tenir pour Alix, en précisant ce que l'infirmière et le diététicien ne doivent pas faire. (2 pts)
5. Citez une limite de cet outil. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.16 – Estimer le nombre d'étudiants concernés par un TCA (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de santé étudiante d'une université de 14 000 étudiants (58 % de femmes, données fictives) veut savoir combien d'étudiants pourraient être concernés par un trouble du comportement alimentaire, pour dimensionner une action de prévention et un circuit d'orientation.

Document 1 – Prévalences vie entière (Hudson et coll., 2007, population adulte des États-Unis ; ordres de grandeur repris par la HAS)

Trouble	Femmes	Hommes
Anorexie mentale	0,9 %	0,3 %
Boulimie	1,5 %	0,5 %
Hyperphagie boulimique	3,5 %	2,0 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de femmes et d'hommes inscrits. (1 pt)
2. Appliquez les prévalences du document 1 pour estimer, pour chaque trouble, le nombre de femmes, d'hommes et le total (arrondis à l'unité). (4 pts)
3. Calculez le total des trois troubles et ce qu'il représente en pourcentage des étudiants. (1 pt)
4. Donnez quatre raisons d'être prudent avec cette estimation. (2 pts)
5. Proposez une action de prévention universelle et une action de repérage et d'orientation adaptées au service de santé étudiante. (3 pts)
6. Expliquez pourquoi on n'utilise pas le questionnaire SCOFF en atelier collectif. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.17 – Analyser une publication « détox » (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse critique · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une conseillère principale d'éducation d'un lycée vous montre une publication très partagée par les élèves sur un réseau social. Elle vous demande de préparer une intervention de 30 minutes pour des classes de première.

Document 1 – La publication (texte reconstitué pour l'entraînement)

« 🔥 CURE DÉTOX 7 JOURS : −5 KG GARANTIS 🔥 Seulement des jus verts et mes gélules brûle-graisses. Zéro pain, zéro sucre, zéro gras : le gras c'est le poison ! Si tu craques, recommence à zéro. Mon corps de rêve en une semaine, et toi, tu attends quoi ? Code promo LÉA20. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez quatre éléments du document 1 qui posent problème et expliquez pourquoi. (4 pts)
2. On estime souvent qu'un kilogramme de tissu adipeux correspond à environ 7 700 kcal (approximation classique de Wishnofsky, 1958). Calculez le déficit énergétique total puis quotidien qu'il faudrait pour perdre 5 kg de graisse en 7 jours. Concluez. (2 pts)
3. Expliquez ce que l'on perd réellement en quelques jours de restriction sévère, et ce qui se passe à l'arrêt. (2 pts)
4. Montrez en quoi ce type de publication peut favoriser la restriction cognitive et, chez certains jeunes, un TCA. (2 pts)
5. Proposez deux activités pour l'intervention, qui développent l'esprit critique sans stigmatiser les élèves qui ont suivi ce type de cure. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.18 – « Faire le poids » en section sportive de judo (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le collège Jean-Moulin de Vernay (données fictives) a une section sportive de judo de 28 élèves de 12 à 15 ans. Avant les compétitions, certains élèves essaient de « descendre de catégorie de poids ». L'infirmière scolaire est inquiète et demande au professeur d'éducation physique et à l'entraîneur du club de vous associer à un projet. L'entraîneur vous demande, lui, « un régime à donner aux élèves avant les compétitions ».

Document 1 – Questionnaire anonyme rempli par les 28 élèves (données fictives)

Question	Réponses « oui »
J'ai déjà essayé de perdre du poids avant une compétition	11
J'ai déjà sauté des repas pour « faire le poids »	6
J'ai déjà fait du sport avec un vêtement de pluie ou un sac poubelle pour transpirer	4
Je pense souvent à mon poids	15
Je mange au self tous les midis	22

Document 2 – Ce que disent des élèves et des adultes

Une élève : « Si je pèse 200 g de trop, l'entraîneur crie. » Un élève : « La veille de la pesée, je ne bois plus rien. » L'entraîneur : « Ils doivent apprendre la rigueur, c'est le sport. » Un parent : « Ma fille ne mange plus de pain depuis septembre. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de « oui » pour chaque question. (2,5 pts)
2. Identifiez dans les documents trois facteurs de risque de TCA et un facteur de protection possible. (3 pts)
3. Expliquez les risques de la déshydratation volontaire et du saut de repas chez un adolescent en croissance qui fait du sport. (2 pts)
4. Rédigez votre réponse à l'entraîneur, qui demande un régime : refus argumenté et proposition alternative, en quelques lignes. (2,5 pts)
5. Proposez un plan d'action en trois volets (adultes encadrants, élèves, familles), sans pesée ni régime. (4 pts)
6. Indiquez la conduite à tenir pour la jeune fille qui « ne mange plus de pain depuis septembre ». (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 4.13

1. Légendes : 1 Insatisfaction corporelle, volonté de maigrir ; 2 Restriction cognitive : des règles remplacent les sensations ; 3 Frustration, faim, envies des aliments interdits ; 4 Perte de contrôle, « craquage » ; 5 Culpabilité, baisse de l'estime de soi ; 6 Reprise de poids, nouveau régime.
2. Herman et Polivy (1975) : intention de contrôler son alimentation par des règles mentales (interdits, calculs, horaires imposés) plutôt que par les sensations de faim et de satiété, pour maigrir ou ne pas grossir.
3. Au point de départ (1 et 2) : avant que la personne n'entre dans les règles. Messages : « Aucun aliment n'est interdit : c'est la quantité et la fréquence qui comptent. » ; « Votre corps sait dire quand il a faim et quand il en a assez : apprenons à l'écouter. » On peut aussi agir à l'étape 5 : « Un écart n'est pas un échec : le repas suivant se passe normalement, sans compenser. »

Corrigé – Exercice 4.14

1. a) externalité (signal de l'heure) ; b) grignotage (automatique, devant un écran : aussi externalité) ; c) restriction cognitive suivie de désinhibition ; d) alimentation émotionnelle ; e) compulsion ; f) rassasiement sensoriel spécifique (chaque nouvel aliment relance l'envie) ; g) externalité (signal visuel) ; h) faim et collation prévue.
2. L'annonce d'une maladie chronique pousse souvent à s'imposer des règles très strictes (« plus de pain, plus de sucre »), par peur ou par incompréhension du traitement. Ces interdits créent de la frustration et finissent en perte de contrôle. Il faut expliquer que le pain reste possible en quantité adaptée, au sein d'un repas.
3. La phrase h) : la personne repère une vraie faim et y répond par une collation prévue, en quantité adaptée, avec des aliments rassasiants.
4. Une dégustation lente d'un aliment (un carré de chocolat, un quartier d'orange), en décrivant aspect, odeur, texture et goût ; l'utilisation d'une échelle de faim de 0 à 10 avant, au milieu et à la fin d'un repas partagé ; un carnet de « déclencheurs » (heure, lieu, émotion) pour repérer les prises sans faim ; un échange sur les alternatives aux réponses émotionnelles (marcher, appeler quelqu'un, respirer).

Corrigé – Exercice 4.15

1. Alix : 4 + 4 + 3 + 4 = 15 sur 16. Bilal : 1 + 1 + 2 + 1 = 5. Chloé : 2 + 3 + 3 + 2 = 10. Dorian : 1 + 2 + 1 + 1 = 5.
2. Q5 : (4 + 1 + 3 + 2) / 4 = 10 / 4 = 2,5. Q6 : (2 + 1 + 4 + 3) / 4 = 10 / 4 = 2,5.
3. Alix : règles très fortes (15 sur 16) et désinhibition maximale (Q5 = 4) : profil de restriction cognitive rigide avec perte de contrôle, et comportement de compensation (sauter le repas après un écart). Bilal : peu de règles et peu de désinhibition ni d'alimentation émotionnelle : il semble manger avec ses sensations. Chloé : règles moyennes (10), désinhibition marquée (3) et alimentation émotionnelle forte (Q6 = 4) : la restriction s'associe à la gestion des émotions par la nourriture. Dorian : peu de règles, mais une alimentation émotionnelle assez fréquente (3) : le travail porte plutôt sur le stress.
4. L'infirmière propose à Alix un entretien individuel, confidentiel et bienveillant, pour parler de son rapport à l'alimentation et de son bien-être, et l'oriente vers le médecin du service de santé étudiante si des signes d'alerte apparaissent (perte de poids, vomissements, crises, isolement). On ne pose pas de diagnostic à partir du questionnaire, on n'en parle pas devant le groupe, on ne propose pas de régime et on ne commente pas son poids.
5. Le questionnaire n'est pas validé ; les réponses sont déclaratives et sensibles à la désirabilité sociale ; quatre étudiants volontaires ne représentent pas la population ; un score ne dit pas l'origine ni la gravité du comportement.

Corrigé – Exercice 4.16

1. Femmes : 14 000 × 0,58 = 8 120 ; hommes : 14 000 − 8 120 = 5 880.

2. Anorexie mentale : femmes 8 120 × 0,009 = 73,1, soit 73 ; hommes 5 880 × 0,003 = 17,6, soit 18 ; total 90,7, soit environ 91. Boulimie : femmes 8 120 × 0,015 = 121,8, soit 122 ; hommes 5 880 × 0,005 = 29,4, soit 29 ; total 151,2, soit environ 151. Hyperphagie boulimique : femmes 8 120 × 0,035 = 284,2, soit 284 ; hommes 5 880 × 0,020 = 117,6, soit 118 ; total 401,8, soit environ 402.

3. Total : 90,7 + 151,2 + 401,8 = 643,7, soit environ 644 étudiants, ou 643,7 / 14 000 × 100 = 4,6 % des étudiants.

4. Les prévalences viennent d'une population adulte des États-Unis, pas d'étudiants français ; ce sont des prévalences vie entière (une partie des troubles est passée ou à venir), pas des cas actuels ; une même personne peut avoir eu plusieurs troubles (les totaux se recouvrent) ; les définitions ont changé avec le DSM-5 (2013) ; les formes « non spécifiées », plus fréquentes, ne sont pas comptées ; beaucoup de personnes ne sont jamais diagnostiquées. L'ordre de grandeur reste utile : plusieurs centaines d'étudiants sont concernés.

5. Prévention universelle : campagne et ateliers « bien manger sans se priver » centrés sur le plaisir, les repas réguliers et l'esprit critique face aux contenus minceur, sans parler de poids, avec les associations étudiantes. Repérage et orientation : former les infirmières, les médecins et les relais étudiants aux signes d'alerte et à la conduite à tenir ; afficher un circuit clair (consultation au service de santé étudiante, liste des structures spécialisées et des lignes d'écoute, annuaire de la Fédération française anorexie boulimie).

6. Le SCOFF est un outil de repérage individuel destiné aux professionnels de santé, dans une relation de soin ; il ne pose pas de diagnostic. En groupe, il exposerait des réponses intimes, pourrait inquiéter ou étiqueter des personnes sans offrir de suivi immédiat.

Corrigé – Exercice 4.17

1. « −5 kg garantis » en 7 jours : promesse impossible et trompeuse (voir question 2). « Seulement des jus verts » : régime très restrictif, carencé en protéines, en énergie et en de nombreux nutriments. « Gélules brûle-graisses » et « code promo » : intérêt commercial, produits sans preuve d'efficacité et parfois dangereux. « Le gras c'est le poison », « zéro pain, zéro sucre » : classement des aliments en interdits, qui alimente la restriction cognitive. « Si tu craques, recommence à zéro » : culpabilisation, cycle restriction-craquage. « Mon corps de rêve » : idéal de minceur, comparaison sociale, insatisfaction corporelle.

2. 5 × 7 700 = 38 500 kcal de déficit total ; 38 500 / 7 = 5 500 kcal par jour. C'est plus que la dépense totale d'une adolescente ou d'un adolescent (souvent entre 2 000 et 3 000 kcal par jour) : même sans rien manger, il est impossible de perdre 5 kg de graisse en une semaine.

3. On perd surtout de l'eau et le glycogène (réserves de glucides stockées avec de l'eau), un peu de muscle, et peu de graisse. À l'arrêt, l'eau et le glycogène se reconstituent : le poids remonte en quelques jours, souvent avec une sensation d'échec et l'envie de recommencer.

4. La publication pousse à remplacer les sensations par des règles (interdits, « zéro ») et à recommencer après chaque craquage : c'est le cercle de la restriction cognitive. Chez des jeunes vulnérables (insatisfaction corporelle, perfectionnisme, moqueries), cette restriction peut être la porte d'entrée d'une anorexie mentale ou de crises de boulimie.

5. Exemples : un « décodage » de publications en petits groupes avec une grille (qui parle ? que vend-il ? quelle preuve ? quelles émotions vise-t-il ?) ; un jeu de rôle où les élèves écrivent la réponse d'un ami bienveillant à la publication ; un calcul guidé comme celui de la question 2. On ne cite aucun élève et on rappelle qu'en cas de besoin, on peut parler à l'infirmière.

Corrigé – Exercice 4.18

1. Essayé de perdre du poids : 11 / 28 × 100 = 39,3 % ; sauté des repas : 6 / 28 = 21,4 % ; vêtement de pluie ou sac : 4 / 28 = 14,3 % ; pense souvent à son poids : 15 / 28 = 53,6 % ; mange au self tous les midis : 22 /

28 = 78,6 %.

2. Facteurs de risque : sport à catégorie de poids avec pression pour « descendre » ; préoccupation fréquente pour le poids (53,6 %) ; pratiques de restriction et de déshydratation ; pression de l'adulte (« l'entraîneur crie ») ; éviction d'un aliment depuis plusieurs mois. Facteur de protection possible : le repas au self, régulier, pour 78,6 % des élèves ; l'implication de l'infirmière et du professeur, qui permet un environnement plus attentif.

3. La déshydratation diminue la force, la vigilance et la coordination, augmente le risque de malaise, de blessure et de coup de chaleur ; elle fatigue les reins. Sauter des repas prive l'organisme de l'énergie et des nutriments nécessaires à la croissance (protéines, calcium, fer) et à l'entraînement ; chez l'adolescent, cela peut retarder la croissance et la puberté, fragiliser les os et ouvrir la voie à un TCA.

4. « Je comprends votre souhait d'aider les élèves à être performants. Chez des adolescents en croissance, un régime avant la compétition est dangereux et ne rend pas plus fort : il fait perdre de l'eau et du muscle, pas de la graisse. Je vous propose plutôt de travailler ensemble sur l'alimentation qui fait gagner : repas réguliers, collations avant l'entraînement, hydratation, et de discuter avec le club d'une catégorie adaptée au poids réel de chaque élève. »

5. Adultes : formation de l'entraîneur, du professeur et de l'infirmière (besoins de l'adolescent sportif, risques des pertes de poids rapides, signes d'alerte, vocabulaire à éviter sur le poids et le corps, conduite à tenir) ; règle commune : aucune pesée hors des pesées officielles, aucune remarque sur le poids. Élèves : deux ateliers « manger pour grandir et performer » (collations, hydratation, repas avant compétition), avec dégustation, et un temps sur les contenus minceur des réseaux sociaux. Familles : réunion d'information avec l'infirmière et le médecin scolaire, fiche « la veille et le jour de la compétition ».

6. L'infirmière en parle avec elle en privé, avec bienveillance, sans parler de son poids ; elle prévient la famille et l'oriente vers le médecin scolaire ou le médecin traitant pour une évaluation. Une éviction durable d'un aliment de base chez une adolescente sportive peut être un signe d'alerte de TCA : il faut une évaluation médicale, pas un conseil diététique collectif.

Partie 4 – Les déterminants du comportement alimentaire

Objectifs – Objectifs de la partie

- Classer les déterminants du comportement alimentaire d'un individu ou d'un groupe (biologiques et sensoriels, psychologiques, cognitifs, sociaux et culturels, économiques, environnementaux) et choisir un levier pour chacun.
- Définir l'environnement obésogène et proposer des actions sur l'environnement.
- Décrire les stratégies alimentaires des ménages en situation de précarité, sans jugement.
- Calculer et interpréter le coût de 100 kcal et le coût des fibres de quelques aliments.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Six familles de déterminants : biologiques et sensoriels (goût inné du sucré, âge, santé) ; psychologiques (émotions, stress, apprentissages, image du corps) ; cognitifs (connaissances, croyances, littératie) ; sociaux et culturels (famille, pairs, normes, religion, genre) ; économiques (revenus, prix, budget) ; environnementaux (offre, portions, marketing, temps, équipement).
- Environnement obésogène : environnement qui favorise la consommation excessive d'énergie et la sédentarité (offre abondante d'aliments très palatables et bon marché, grandes portions, marketing, écrans, déplacements motorisés). Il justifie d'agir sur l'environnement et pas seulement sur la responsabilité individuelle.
- Stratégies des ménages précaires : réduire la qualité pour préserver la quantité, prioriser les enfants, faire durer, recourir à l'aide alimentaire, préserver des moments de plaisir. Savoir faire durer un budget est une compétence.
- Les aliments denses en énergie (sucres et matières grasses ajoutés, céréales raffinées) apportent les calories les moins chères ; les fruits et légumes apportent des calories plus chères mais beaucoup de nutriments (Drewnowski et Darmon, 2005).
- Depuis le 1er septembre 2005, les distributeurs automatiques payants de boissons et d'aliments sont interdits dans les établissements scolaires (loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, article 30).

Exercice 4.19 – Légender les déterminants du comportement alimentaire (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une formation pour des aides à domicile sur le thème « pourquoi les personnes mangent ce qu'elles mangent ».

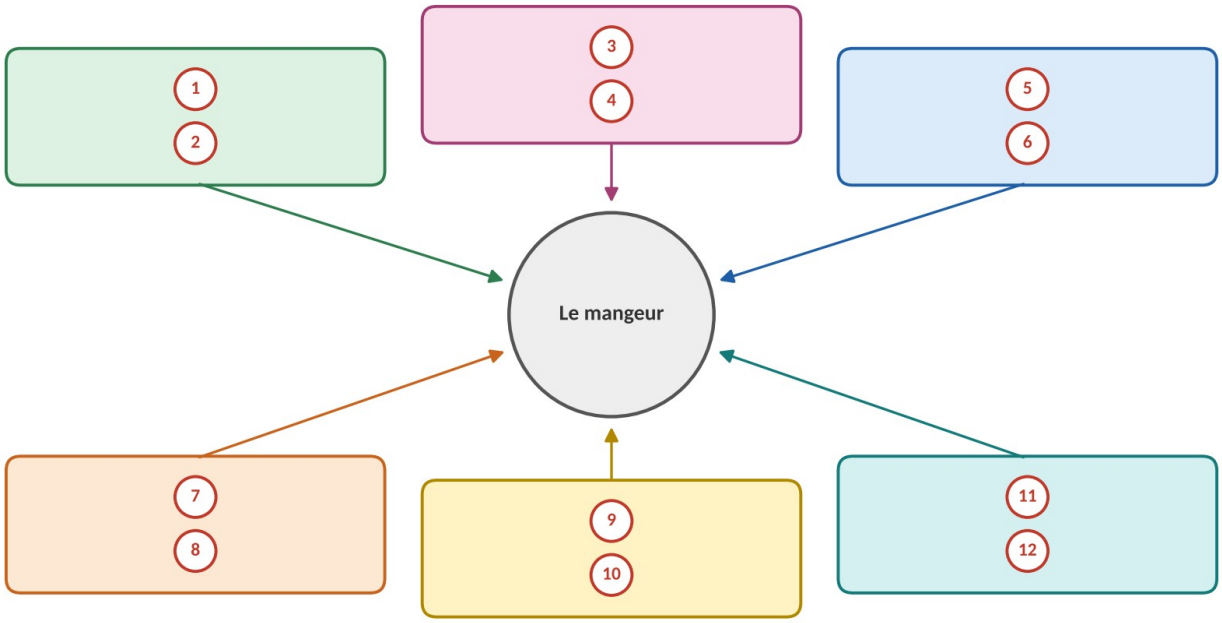


Figure 4.5 – Document 1 – Les déterminants du comportement alimentaire (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1 : le nom de chaque famille de déterminants et deux ou trois exemples. (6 pts)
2. Donnez pour trois familles un levier éducatif adapté au travail des aides à domicile. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.20 – Les déterminants d'une personne (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre d'un projet de prévention mené par un service de santé au travail, vous avez réalisé un entretien avec Mme R., 52 ans, aide à domicile. Elle a donné son accord pour que ses propos, rendus anonymes, servent à la formation.

Document 1 – Extraits de l'entretien

« Je commence à 7 h et je finis à 19 h, avec des trous entre deux interventions. Je mange dans la voiture, souvent un sandwich de la boulangerie ou des biscuits. Le soir je suis trop fatiguée pour cuisiner. Depuis la ménopause, j'ai pris du poids, ça me travaille, je me trouve moche. On m'a dit que le pain fait grossir, alors j'essaie de ne plus en manger. Avec mon salaire, les fruits, c'est un luxe. Chez moi, au Portugal, on mangeait de la soupe tous les soirs, ma mère la faisait. J'aime le salé, je mets du sel avant de goûter. Mes collègues font pareil, on n'a pas le temps. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez dans le document 1 au moins un déterminant de chacune des six familles. (6 pts)
2. Repérez une croyance erronée et une situation à risque de restriction cognitive. (2 pts)
3. Proposez deux leviers réalistes, compatibles avec ses horaires et son budget. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.21 – L'environnement autour d'un lycée professionnel (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement (CESCE) d'un lycée professionnel de 650 élèves veut agir sur l'alimentation des élèves, qui sortent souvent à midi. Des élèves de terminale ont fait un relevé de l'environnement alimentaire dans un rayon de 500 m autour du lycée. Ils ont aussi relevé le contenu des deux distributeurs installés dans le hall du lycée.

Document 1 – Relevé de l'offre (données fictives, octobre 2026)

Type de point de vente dans un rayon de 500 m	Nombre
Restauration rapide (burgers, kebabs, tacos, pizzas)	9
Boulangeries	3
Supérettes	2
Primeur (fruits et légumes)	1
Total	15

Document 2 – Contenu des deux distributeurs du hall (48 emplacements)

Produit	Emplacements
Barres chocolatées, biscuits, chips	30
Sodas et boissons énergisantes	12
Eau	4
Compotes à boire	2

Document 3 – Prix relevés (données fictives)

Menu burger-frites-soda le plus vendu : 5,90 €. Repas complet au self du lycée : 3,60 €. Fréquentation du self : 290 élèves par jour en moyenne.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de la restauration rapide dans l'offre du quartier, puis le rapport entre le nombre de restaurations rapides et le nombre de primeurs. (2 pts)
2. Calculez la part des emplacements des distributeurs occupés par des produits gras, sucrés ou salés et par des boissons sucrées, puis la part de l'eau. (2 pts)
3. Calculez le taux de fréquentation du self et l'écart de prix entre le menu burger et le repas du self. (2 pts)
4. Montrez, à l'aide de ces données, que cet environnement est obésogène. (2 pts)
5. Indiquez ce que dit la loi sur les distributeurs du hall et ce que le lycée doit faire. (1 pt)
6. Proposez trois actions sur l'environnement, et non sur la seule responsabilité des élèves. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.22 – Les stratégies des familles à l'épicerie solidaire (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans une épicerie solidaire. Une nouvelle bénévole vous dit : « Ces familles mangent mal parce qu'elles ne savent pas. Il faudrait leur faire des cours de nutrition. » Vous avez noté ce que des bénéficiaires vous ont dit pendant les distributions.

Document 1 – Ce que disent des bénéficiaires

a) « J'achète des pâtes et du riz en gros, ça cale et ça dure. Les légumes, ça s'abîme vite. »

b) « Moi je mange après les enfants, ce qui reste. Des fois il ne reste pas grand-chose. »

c) « Je fais les courses tous les deux jours, avec ce que j'ai sur le compte. Je regarde toutes les promotions. »

d) « Ici, au moins, je choisis mes produits. Au colis, on prenait ce qu'on nous donnait, j'avais honte. »

e) « Le mercredi, j'achète des bonbons à mes enfants. Ils ont le droit d'être comme les autres. »

f) « Je sais faire un repas pour cinq avec 6 €, ma mère m'a appris. »

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque phrase du document 1 à une stratégie des ménages en situation de précarité. (3 pts)
2. Répondez à la bénévole en trois ou quatre phrases argumentées. (3 pts)
3. Proposez deux actions qui reconnaissent les compétences des familles et respectent leur besoin de plaisir et de dignité. (2 pts)
4. Citez deux leviers d'accès, et pas seulement d'information. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.23 – Le prix des calories (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un atelier « faire ses courses malin » dans un centre social, vous voulez montrer pourquoi les aliments gras et sucrés paraissent « moins chers » et pourquoi ce n'est pas toute la vérité.

Document 1 – Prix relevés (fictifs, octobre 2026) et composition pour 100 g (Ciqual 2025)

Aliment (code Ciqual)	Prix au kilo	Énergie (kcal pour 100 g)	Fibres (g pour 100 g)
Lentilles sèches (20359)	2,60 €	327	16,3
Pâtes sèches (9810)	1,40 €	364	2,91
Carottes crues (20009)	1,50 €	30,2	2,9
Pommes (13039)	2,40 €	54	1,4
Biscuits secs (24001)	3,00 €	438	3,3
Pâte à tartiner chocolat-noisette (31032)	6,00 €	549	3,23

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque aliment, le coût de 100 kcal (en euros, trois décimales). Classez les aliments du moins cher au plus cher. (4 pts)
2. Calculez le coût de 10 g de fibres pour chaque aliment (en euros, deux décimales). (3 pts)
3. Comparez les classements obtenus aux questions 1 et 2. Que montrent-ils ? (2 pts)
4. Expliquez pourquoi un ménage au budget serré, qui doit d'abord « remplir le ventre », se tourne vers les aliments denses en énergie (Drewnowski et Darmon, 2005). (1 pt)
5. Rédigez deux messages pour l'atelier qui mettent en avant les aliments à la fois bon marché et riches en nutriments. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.24 – Les jeunes de la mission locale (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

La mission locale de Saint-Rémy (données fictives) accompagne des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, vers l'emploi et la formation. Les conseillers constatent que beaucoup de jeunes arrivent le matin sans avoir mangé et ont du mal à se concentrer en atelier. La directrice dispose d'un budget de 2 000 € et vous demande un diagnostic et un projet.

Document 1 – Questionnaire rempli par 120 jeunes accompagnés (données fictives)

Situation	Nombre de jeunes
Budget alimentaire inférieur à 50 € par semaine	74
Pas d'équipement pour cuisiner (ni plaque, ni four)	18
Hébergé chez un tiers (ami, famille élargie)	31
Mange au moins 3 fois par semaine en restauration rapide	52
A sauté des repas faute d'argent au cours du dernier mois	45
Connaît l'épicerie solidaire du quartier	28

Document 2 – Ce que disent des jeunes

« Chez mon pote, je ne peux pas me servir dans le frigo. » « Le kebab à 6 €, ça me fait le midi et le soir. » « Mes potes mangent au fast-food, je ne vais pas manger tout seul. » « Je ne sais pas faire grand-chose, à part des pâtes. » « Le matin je n'ai pas faim, et puis à 11 h j'ai la tête qui tourne. » « Les légumes, je n'aime pas, sauf ceux de ma tante. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de jeunes concernés par chaque situation du document 1. (3 pts)
2. Classez les déterminants mis en évidence par les documents 1 et 2 dans les six familles. (4 pts)
3. Formulez un objectif général et deux objectifs spécifiques. (2 pts)
4. Proposez trois actions, chacune reliée à un déterminant, et un budget qui respecte les 2 000 €. (5 pts)
5. Indiquez deux précautions éthiques dans ce projet. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 4.19

1. Légendes : 1 Biologiques et sensoriels ; 2 goût inné du sucré, âge, santé ; 3 Psychologiques ; 4 émotions, stress, apprentissages, image du corps ; 5 Cognitifs ; 6 connaissances, croyances, littératie ; 7 Sociaux et culturels ; 8 famille, pairs, normes, religion, genre ; 9 Économiques ; 10 revenus, prix, budget alimentaire ; 11 Environnementaux ; 12 offre, portions, marketing, temps, équipement.
2. Biologiques et sensoriels : adapter les textures et relever le goût avec des herbes et des épices chez une personne âgée qui perd le goût. Sociaux : proposer de partager un moment du repas, ou orienter vers un repas collectif du quartier. Économiques : préparer une liste de courses à petit prix avec la personne. Environnementaux : aider à organiser le réfrigérateur et les placards pour que les aliments faciles à préparer soient visibles.

Corrigé – Exercice 4.20

1. Biologiques et sensoriels : âge, ménopause, préférence pour le salé (« je mets du sel avant de goûter »). Psychologiques : image du corps dévalorisée (« je me trouve moche »), fatigue. Cognitifs : croyance « le pain fait grossir ». Sociaux et culturels : habitudes portugaises (soupe du soir transmise par la mère), normes de l'équipe (« mes collègues font pareil »). Économiques : salaire modeste, fruits jugés « un luxe ». Environnementaux : horaires longs et morcelés, repas dans la voiture, offre de la boulangerie, manque de temps le soir.
2. Croyance erronée : le pain ne « fait pas grossir » en lui-même ; c'est l'équilibre de l'ensemble et les quantités qui comptent. Situation à risque : l'insatisfaction corporelle associée à l'éviction du pain peut l'entraîner dans le cercle de la restriction cognitive.
3. Exemples : préparer le dimanche une grande soupe de légumes, comme sa mère, à emporter dans une bouteille isotherme (rôle culturel valorisé, rapide, peu coûteux) ; garder dans la voiture des aliments simples et bon marché (pain, fromage, fruits de saison en promotion, bananes, compotes sans sucres ajoutés) ; goûter avant de saler.

Corrigé – Exercice 4.21

1. Restauration rapide : 9 / 15 × 100 = 60,0 % de l'offre. Rapport : 9 / 1 = 9 restaurations rapides pour un primeur.
2. Produits gras, sucrés ou salés et boissons sucrées : (30 + 12) / 48 × 100 = 42 / 48 × 100 = 87,5 % des emplacements. Eau : 4 / 48 × 100 = 8,3 %.
3. Fréquentation du self : 290 / 650 × 100 = 44,6 %. Écart de prix : 5,90 − 3,60 = 2,30 € ; le repas du self coûte 2,30 € de moins et pourtant plus de la moitié des élèves mangent ailleurs.
4. L'offre la plus proche et la plus visible est composée d'aliments très palatables, denses en énergie (60 % de restauration rapide, 87,5 % de produits gras, sucrés ou salés dans les distributeurs) ; l'offre de fruits et légumes est rare (un primeur) ; ces produits sont disponibles à toute heure, y compris dans le lycée. Choisir une alimentation équilibrée demande un effort permanent : c'est un environnement obésogène. Le prix ne suffit pas à expliquer les choix : l'ambiance, les pairs et l'image du self comptent aussi.
5. Les distributeurs automatiques payants de boissons et d'aliments sont interdits dans les établissements scolaires depuis le 1er septembre 2005 (loi n° 2004-806 du 9 août 2004, article 30) : le lycée doit les retirer. Une fontaine à eau reste possible.
6. Retirer les distributeurs et installer des fontaines à eau ; travailler avec le gestionnaire du self sur l'attractivité (menu « comme au fast-food » maison une fois par semaine, choix des élèves, ambiance, temps d'attente, horaires) ; associer la municipalité à une réflexion sur l'implantation de commerces près des établissements scolaires et aux abords des arrêts de bus ; proposer un partenariat avec le primeur ou une boulangerie (formule à prix réduit avec fruit pour les lycéens).

Corrigé – Exercice 4.22

1. a) réduire la qualité pour préserver la quantité (féculents qui « calent », peu de légumes) et faire durer ; b) prioriser les enfants ; c) faire durer (achats au jour le jour, promotions) ; d) recourir à l'aide alimentaire, avec le souci de la dignité ; e) préserver des moments de plaisir (besoin de normalité) ; f) compétence de gestion du budget, transmise par la famille.

2. « Les familles ne mangent pas ainsi par ignorance : elles s'adaptent à des contraintes fortes, d'argent, de logement, de temps et de stress. Elles ont même des compétences, comme faire un repas pour cinq avec 6 €. Un cours de nutrition qui leur dirait quoi manger, sans leur donner les moyens de le faire, risquerait de les culpabiliser. Il vaut mieux partir de ce qu'elles savent faire et améliorer l'accès aux produits. »

3. Un atelier « nos recettes à petit prix » où les bénéficiaires partagent leurs savoir-faire, enrichi par l'ajout de légumes de saison et de légumes secs proposés à l'épicerie ; un goûter festif préparé ensemble pour les enfants, avec gâteau maison et fruits, qui garde la dimension de plaisir.

4. Mettre en avant à l'épicerie des légumes de saison et des légumes secs à très petit prix ; proposer des légumes surgelés et en conserve, qui ne s'abîment pas ; organiser des paniers solidaires de producteurs locaux ; informer sur les autres aides (chèques alimentaires, restaurants sociaux, jardins partagés).

Corrigé – Exercice 4.23

1. Coût de 100 kcal = prix au kilo / (énergie pour 100 g × 10) × 100. Lentilles : 2,60 / 3 270 × 100 = 0,080 €. Pâtes : 1,40 / 3 640 × 100 = 0,038 €. Carottes : 1,50 / 302 × 100 = 0,497 €. Pommes : 2,40 / 540 × 100 = 0,444 €. Biscuits : 3,00 / 4 380 × 100 = 0,068 €. Pâte à tartiner : 6,00 / 5 490 × 100 = 0,109 €. Classement : pâtes (0,038) < biscuits (0,068) < lentilles (0,080) < pâte à tartiner (0,109) < pommes (0,444) < carottes (0,497).

2. Quantité d'aliment pour 10 g de fibres = 10 / fibres pour 100 g × 100. Lentilles : 61,3 g, soit 0,0613 × 2,60 = 0,16 €. Pâtes : 343,6 g, soit 0,48 €. Carottes : 344,8 g, soit 0,52 €. Pommes : 714,3 g, soit 1,71 €. Biscuits : 303,0 g, soit 0,91 €. Pâte à tartiner : 309,6 g, soit 1,86 €.

3. Pour l'énergie, les biscuits et la pâte à tartiner sont parmi les moins chers, et les carottes et les pommes sont les plus chères (6,5 à 7,3 fois le prix des biscuits : 0,444 / 0,068 et 0,497 / 0,068). Pour les fibres, le classement change : les lentilles sont de loin les moins chères, les carottes coûtent presque deux fois moins que les biscuits, et la pâte à tartiner est la plus chère. Le prix des calories ne dit pas la valeur nutritionnelle ; les lentilles et les pâtes sont à la fois peu chères en calories et en nutriments.

4. Quand le budget est très serré, la priorité est de ne pas avoir faim : on achète les calories les moins chères, c'est-à-dire des aliments denses en énergie (sucres et graisses ajoutés, céréales raffinées). C'est un choix rationnel sous contrainte, pas un manque de connaissances.

5. « Les lentilles : 8 centimes les 100 kcal, et les fibres les moins chères du rayon. » ; « Carottes, chou, pommes de saison : chers en calories, mais les champions des vitamines au meilleur prix. » On peut ajouter : « Légumes surgelés nature : pas de perte, pas de gaspillage. »

Corrigé – Exercice 4.24

1. Budget inférieur à 50 € : 74 / 120 × 100 = 61,7 % ; pas d'équipement : 18 / 120 = 15,0 % ; hébergé chez un tiers : 31 / 120 = 25,8 % ; restauration rapide au moins 3 fois par semaine : 52 / 120 = 43,3 % ; repas sautés faute d'argent : 45 / 120 = 37,5 % ; connaît l'épicerie solidaire : 28 / 120 = 23,3 %.

2. Biologiques et sensoriels : absence de faim le matin, malaise à 11 h ; préférence limitée pour les légumes. Psychologiques : gêne d'être hébergé (« je ne peux pas me servir »), stress de la situation d'insertion. Cognitifs : peu de compétences culinaires (« à part des pâtes ») ; méconnaissance des aides (23,3 % seulement connaissent l'épicerie solidaire). Sociaux et culturels : influence des pairs (« je ne vais pas manger tout seul »), place de la famille (« ceux de ma tante »). Économiques : 61,7 % ont moins de 50 € par semaine, 37,5 % ont sauté des repas. Environnementaux : hébergement chez un tiers (25,8 %), pas d'équipement (15,0 %), restauration rapide accessible.

3. Objectif général : améliorer l'accès des jeunes accompagnés par la mission locale à une alimentation

suffisante et équilibrée, pour soutenir leur parcours d'insertion. Objectifs spécifiques : d'ici juin 2027, faire passer de 23,3 % à au moins 60 % la part des jeunes qui connaissent l'épicerie solidaire et les aides alimentaires ; d'ici juin 2027, réduire de 37,5 % à moins de 25 % la part des jeunes qui sautent des repas faute d'argent.

4. Action 1, petit-déjeuner partagé deux matins par semaine avant les ateliers (pain, beurre, lait, yaourts, fruits) : déterminants économiques et biologiques (repas sauté, malaise de 11 h) ; budget 30 semaines × 2 matins × 15 jeunes × 1,00 € = 900,00 €. Action 2, quatre ateliers « cuisine sans cuisine » (recettes sans four ni plaque : salades complètes, wraps, bocaux) et « cuisine à 1 € la portion », animés avec une conseillère : déterminants cognitifs et environnementaux ; denrées 4 × 80,00 € = 320,00 €, petit matériel (boîtes, bouilloires) 250,00 €. Action 3, visite de l'épicerie solidaire et permanence mensuelle d'un bénévole à la mission locale, livret des aides : déterminants cognitifs et économiques ; livret 150,00 €. Sous-total : 900,00 + 320,00 + 250,00 + 150,00 = 1 620,00 € ; imprévus et goûters des ateliers : 2 000 − 1 620 = 380,00 € (19,0 %) ; total 2 000,00 €.

5. Le petit-déjeuner est ouvert à tous, sans justifier de sa situation, pour éviter la stigmatisation ; les réponses au questionnaire restent anonymes ; aucune information sur la situation alimentaire d'un jeune n'est transmise à un employeur ou à un organisme de formation ; les ateliers sont volontaires et valorisent ce que les jeunes savent déjà faire.

Partie 5 – Évolution des pratiques et pratiques alimentaires actuelles

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire le modèle alimentaire français et ses transformations ; définir le syncrétisme culinaire.
- Reconnaître les principales pratiques alimentaires actuelles et leurs points de vigilance nutritionnelle.
- Adapter une recette ou un atelier aux pratiques religieuses et aux choix éthiques des participants, sans supposer ni juger.
- Calculer les apports en protéines, en fer et en vitamine C d'un plat végétarien avec la table Ciqual 2025.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Modèle français : trois repas à heures régulières, à table, en commun, structurés ; il se transforme (baisse de la part du budget alimentaire, produits transformés, restauration hors foyer, livraisons, individualisation, snacking, nouvelles attentes) sans disparaître.
- Syncrétisme culinaire : combinaison, dans une même pratique ou un même plat, d'éléments issus de cultures culinaires différentes.
- En 2020, environ 2 % des 15-70 ans sont végétariens, pescétariens ou végétaliens et 24 % se disent flexitariens (Ifop pour FranceAgriMer).
- Végétarisme (lacto-ovo) : ni viande ni poisson ; vigilance sur le fer, le zinc, les oméga-3 à longue chaîne, l'iode. Végétalisme : aucun produit animal ; supplémentation en vitamine B12 obligatoire ; vigilance sur le calcium, la vitamine D, l'iode, le zinc, le fer, les oméga-3 et les protéines. Le véganisme étend le refus à tous les usages des animaux.
- Fer non héminique (végétal) : mieux absorbé en présence de vitamine C au même repas. Références nutritionnelles de l'ANSES (2021) pour le fer : 11 mg par jour pour les hommes et les femmes aux pertes menstruelles faibles à normales, 16 mg pour les femmes aux pertes élevées.
- Pratiques religieuses : on ne suppose jamais qu'une personne pratique du fait de son origine ; on demande. La laïcité n'oblige pas la restauration collective publique à proposer des menus confessionnels, mais ne l'interdit pas.

Exercice 4.25 – Deux générations à table (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre social veut adapter ses actions aux pratiques de ses adhérents. Il a interrogé 60 adhérents de 18 à 34 ans et 50 adhérents de 60 ans et plus.

Document 1 – Résultats de l'enquête (données fictives)

Pratique	18-34 ans (n = 60)	60 ans et plus (n = 50)
Dîne à table au moins 5 soirs sur 7	33	44
Mange devant un écran au moins une fois par jour	42	14
Commande un repas livré au moins une fois par semaine	27	2
Cuisine des produits bruts au moins 5 jours sur 7	21	38
Regarde le Nutri-Score ou la liste des additifs avant d'acheter	36	19

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de chaque pratique dans chaque groupe, puis l'écart en points entre les deux groupes. (4 pts)
2. Reliez chaque résultat à une transformation du modèle alimentaire français décrite dans le cours. (3 pts)
3. Montrez que le modèle français ne disparaît pas chez les jeunes adultes. (1 pt)
4. Expliquez pourquoi on ne peut pas savoir, avec cette enquête, si les jeunes garderont ces pratiques en vieillissant (effet de l'âge ou effet de la génération). (2 pts)
5. Proposez une action adaptée à chaque groupe. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.26 – Le syncrétisme culinaire au marché (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour la fête de quartier, un comité d'habitants prépare un buffet « cuisines d'ici et d'ailleurs ». Les habitants ont proposé une liste de plats.

Document 1 – Plats proposés

a) Couscous aux légumes de saison du marché (potiron, navets, carottes de la région).

b) Blanquette de veau traditionnelle.

c) Galettes de sarrasin garnies de légumes rôtis au curry.

d) Tacos lyonnais (galette de blé, frites, viande, sauce fromagère).

e) Dahl de lentilles vertes du Puy au lait de coco.

f) Tarte aux pommes de la grand-mère d'un habitant.

g) Sushis au saumon fumé et au fromage frais.

h) Mafé de poulet servi avec de la semoule.

À vous de jouer – Questions

1. **Définissez** le syncrétisme culinaire. (2 pts)
2. **Classez** les plats : plat d'une seule tradition culinaire ou plat syncrétique. Pour chaque plat syncrétique, indiquez les cultures combinées. (3 pts)
3. **Citez** deux causes du syncrétisme culinaire. (1 pt)
4. **Expliquez** en quoi le syncrétisme est un levier pour introduire des produits locaux et de saison dans un atelier. Donnez un exemple. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.27 – Reconnaître les pratiques et leurs points de vigilance (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une permanence « alimentation » dans une maison des étudiants. Vous avez noté ce que disent cinq étudiants qui veulent des conseils.

Document 1 – Ce que disent les étudiants

a) Jade : « Je ne mange ni viande ni poisson, mais je mange des œufs, du fromage et des yaourts. »

b) Ilan : « Je mange de tout, mais j'ai décidé de ne manger de la viande que deux fois par semaine. »

c) Nour : « Je ne mange aucun produit animal, ni lait ni œufs ni miel, et je n'achète pas de cuir. »

d) Lucas : « Je ne mange plus de viande, mais je mange du poisson deux fois par semaine. »

e) Emma : « J'ai arrêté le gluten parce qu'une influenceuse dit que ça fait gonfler. Je n'ai pas de maladie. »

À vous de jouer – Questions

1. Nommez la pratique de chaque étudiant. (2,5 pts)
2. Pour Jade, Nour et Lucas, citez deux points de vigilance nutritionnelle et un conseil pour chacun. (4,5 pts)
3. Indiquez le conseil indispensable pour Nour et expliquez pourquoi il ne peut pas être remplacé par l'alimentation seule. (1,5 pt)
4. Indiquez ce que vous dites à Emma, sans la juger. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.28 – Le fer d'un plat végétarien (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le restaurant universitaire propose chaque jour un plat végétarien. Des étudiants demandent si ce plat apporte « assez de fer et de protéines » par rapport au plat de viande. Vous comparez deux déjeuners avec la table Ciqual 2025.

Document 1 – Apports calculés avec Ciqual 2025 (quantités par portion)

Déjeuner	Composition	Énergie	Protéines	Fer	Vitamine C
Végétarien	Dahl : lentilles corail cuites 180 g, riz blanc cuit 150 g, tomate 100 g, oignon 30 g, huile de colza 8 g ; dessert : orange 150 g	618,1 kcal	25,8 g	4,99 mg	92,3 mg
Viande	Steak haché 15 % de matières grasses cuit 100 g, pâtes cuites 200 g, sauce tomate 60 g	620,3 kcal	36,7 g	4,31 mg	3,3 mg

Détail du fer du déjeuner végétarien : lentilles 3,96 mg ; riz (teneur inférieure à 0,25 mg pour 100 g, comptée 0) ; tomate 0,17 mg ; oignon 0,00 mg ; orange 0,85 mg. Teneur des lentilles corail cuites : 2,2 mg de fer pour 100 g (code 20589).

À vous de jouer – Questions

1. Vérifiez par le calcul l'apport en fer des lentilles, puis le total du déjeuner végétarien. (2 pts)
2. Calculez la part de la référence de l'ANSES (2021) couverte par chaque déjeuner pour une étudiante aux pertes menstruelles élevées (16 mg) et pour un étudiant (11 mg). (2 pts)
3. Les deux déjeuners apportent une quantité de fer voisine. Expliquez pourquoi le fer du déjeuner de viande est pourtant mieux absorbé, et le rôle de l'orange dans le déjeuner végétarien. (3 pts)
4. Comparez les apports en protéines. Le déjeuner végétarien apporte-t-il des protéines de bonne qualité ? Justifiez. (2 pts)
5. Indiquez la limite du calcul pour le riz et pour le sel. (1 pt)
6. Proposez deux conseils pour les étudiants végétariens qui mangent au restaurant universitaire. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.29 – Adapter une recette à un groupe aux pratiques variées (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un atelier culinaire de 10 personnes dans une association de quartier. À l'inscription, la fiche de recueil des pratiques (fiche-outil O4.1) indique : trois personnes mangent halal, une personne mange casher, une personne d'origine indienne est végétarienne et ne mange pas d'œufs, une personne est végétalienne, une personne est allergique aux fruits à coque. La recette prévue par l'association est la suivante.

Document 1 – La recette prévue

Lasagnes à la bolognaise pour 10 : 600 g de viande hachée (moitié bœuf, moitié porc), 20 cL de vin rouge dans la sauce, sauce tomate, béchamel au lait et au beurre, 150 g de parmesan, pâtes à lasagnes aux œufs, pesto aux pignons pour la décoration.

À vous de jouer – Questions

1. Repérez, pour chaque pratique ou contrainte, le ou les ingrédients qui posent problème. (4 pts)
2. Proposez une version de la recette qui convienne au plus grand nombre, et justifiez chaque changement. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi l'atelier ne peut pas garantir un repas casher, et ce que vous proposez à la personne concernée. (1 pt)
4. Indiquez comment présenter la recette au groupe sans mettre en avant les religions. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.30 – Le Ramadan au centre de formation d'apprentis (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre de formation d'apprentis (CFA) du bâtiment de Rivesaltes-sur-Loire (données fictives) forme 140 apprentis de 16 à 22 ans, en alternance entre le CFA et les chantiers. L'infirmière a remarqué davantage de malaises pendant le dernier Ramadan. Le directeur vous demande de l'aider à préparer le prochain, « sans faire de différence entre les jeunes » et en respectant les règles de sécurité des ateliers.

Document 1 – Données de l'infirmière (année précédente, données fictives)

Période	Durée	Apprentis présents en moyenne	Malaises signalés
Mois du Ramadan	30 jours	128	9
Reste de l'année scolaire	270 jours	132	18

46 apprentis ont déclaré à l'infirmière, de façon volontaire et confidentielle, jeûner pendant le Ramadan. Un apprenti est diabétique de type 1.

Document 2 – Ce que disent des apprentis

« Le matin, je me lève à 5 h pour manger, après je me recouche, je suis cassé. » « Au moment de la rupture, je mange beaucoup de pâtisseries et de la chorba. » « Sur le chantier, il fait chaud sous le casque. » « Mon patron ne sait pas que je jeûne. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre moyen de malaises par jour dans chaque période, puis le rapport entre les deux. (3 pts)
2. Calculez la part des apprentis qui déclarent jeûner. (1 pt)
3. Expliquez, en lien avec le document 2, trois facteurs qui peuvent expliquer les malaises. (3 pts)
4. Proposez trois conseils pour le repas d'avant l'aube (suhur), la rupture du jeûne et l'hydratation. (3 pts)
5. Proposez deux actions du CFA qui respectent le principe « sans faire de différence entre les jeunes » et la sécurité. (3 pts)
6. Indiquez la conduite à tenir pour l'apprenti diabétique de type 1. (1,5 pt)
7. Rappelez la posture du diététicien face à une pratique religieuse. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 4.25

1. Dîne à table au moins 5 soirs sur 7 : 33 / 60 = 55,0 % et 44 / 50 = 88,0 %, écart 33,0 points en faveur des 60 ans et plus. Écran au moins une fois par jour : 42 / 60 = 70,0 % et 14 / 50 = 28,0 %, écart 42,0 points. Repas livré au moins une fois par semaine : 27 / 60 = 45,0 % et 2 / 50 = 4,0 %, écart 41,0 points. Produits bruts au moins 5 jours sur 7 : 21 / 60 = 35,0 % et 38 / 50 = 76,0 %, écart 41,0 points. Nutri-Score ou additifs : 36 / 60 = 60,0 % et 19 / 50 = 38,0 %, écart 22,0 points en faveur des 18-34 ans.
2. Dîner moins souvent à table et manger devant un écran : individualisation des prises. Repas livrés : développement de la restauration hors foyer et des plateformes de livraison. Moins de cuisine de produits bruts : hausse des produits transformés et des plats préparés. Attention au Nutri-Score et aux additifs : nouvelles attentes de santé et de naturalité, défiance envers l'industrie.
3. Plus de la moitié des 18-34 ans (55,0 %) dînent encore à table au moins 5 soirs sur 7, et un tiers cuisine des produits bruts presque tous les jours : le repas structuré reste une norme, même s'il est moins fréquent.
4. L'enquête est faite à un seul moment (enquête transversale). Les écarts peuvent venir de l'âge (les jeunes adultes vivent seuls, travaillent en horaires décalés, et changeront peut-être de pratiques en fondant une famille) ou de la génération (ils ont grandi avec les écrans et les plateformes et garderont ces pratiques). Il faudrait suivre les mêmes personnes dans le temps (cohorte) pour distinguer les deux effets. Les effectifs sont aussi petits et les adhérents d'un centre social ne représentent pas toute la population.
5. 18-34 ans : atelier « plus rapide qu'une livraison » (recettes en moins de 20 minutes avec des produits bruts) et décodage du Nutri-Score, qu'ils regardent déjà. 60 ans et plus : repas partagés intergénérationnels où ils transmettent leurs recettes aux plus jeunes, ce qui valorise leurs compétences et entretient le lien social.

Corrigé – Exercice 4.26

1. Combinaison, dans une même pratique ou un même plat, d'éléments (ingrédients, techniques, manières de manger) issus de cultures culinaires différentes.
2. Une seule tradition : b) blanquette (cuisine française) ; f) tarte aux pommes (cuisine familiale française). Syncrétiques : a) couscous maghrébin et légumes de la région ; c) galette bretonne et curry d'Asie du Sud ; d) tacos lyonnais, inspiration mexicaine (galette) et cuisine rapide française (frites, sauce fromagère) ; e) dahl d'Asie du Sud et lentilles vertes du Puy, lait de coco ; g) sushis japonais et fromage frais occidental ; h) mafé d'Afrique de l'Ouest servi avec la semoule du Maghreb.
3. Mondialisation et échanges commerciaux ; migrations et acculturation ; médias et restauration (chaînes, livraisons).
4. Un plat que les participants connaissent et aiment sert de « porte d'entrée » : on garde sa structure et son goût, et l'on remplace ou complète certains ingrédients par des produits locaux et de saison. Exemple : un tajine aux légumes d'hiver de la région (potiron, panais, carottes) avec des pois chiches, ou un dahl aux lentilles vertes de France.

Corrigé – Exercice 4.27

1. a) Jade : végétarisme (lacto-ovo-végétarisme) ; b) Ilan : flexitarisme ; c) Nour : végétalisme et véganisme ; d) Lucas : pescétarisme ; e) Emma : régime « sans » par choix, sans justification médicale.
2. Jade : fer (associer légumineuses, céréales complètes et vitamine C au repas) ; oméga-3 à longue chaîne (huile de colza, noix, et poissons gras si elle les accepte un jour) ; zinc et iode (produits laitiers, œufs, sel iodé). Nour : vitamine B12 (supplémentation) ; calcium et vitamine D (boissons végétales enrichies en calcium, légumes verts, eaux riches en calcium) ; fer, zinc, iode, oméga-3, protéines (légumineuses et céréales chaque jour, tofu). Lucas : peu de risques ; manger des poissons variés, dont un poisson gras par semaine, et limiter les grands poissons prédateurs (méthylmercure) en cas de grossesse ; fer (légumineuses, vitamine C).

3. Une supplémentation en vitamine B12 est indispensable : cette vitamine n'est présente en quantité utile que dans les produits animaux. Sans complément, la carence finit par survenir (anémie, troubles neurologiques). Un suivi médical et diététique est recommandé.

4. « C'est votre choix et vous pouvez le faire. Sans maladie cœliaque ni allergie, supprimer le gluten n'a pas de bénéfice démontré pour la santé ; cela coûte souvent plus cher et peut réduire vos apports en fibres. Si vous avez des troubles digestifs, parlez-en à votre médecin avant d'arrêter le gluten, car l'éviction rend ensuite le diagnostic de maladie cœliaque plus difficile. »

Corrigé – Exercice 4.28

1. Lentilles : 180 × 2,2 / 100 = 3,96 mg. Total : 3,96 + 0 + 0,17 + 0,00 + 0,85 = 4,98 mg (4,99 mg avec les teneurs non arrondies de la table).

2. Étudiante, 16 mg : végétarien 4,99 / 16 × 100 = 31,2 % ; viande 4,31 / 16 × 100 = 26,9 %. Étudiant, 11 mg : végétarien 4,99 / 11 × 100 = 45,4 % ; viande 4,31 / 11 × 100 = 39,2 %.

3. Une partie du fer de la viande est du fer héminique, bien absorbé (environ 25 %) et peu influencé par le reste du repas. Le fer des végétaux est non héminique : il est moins bien absorbé (souvent moins de 10 %) et son absorption dépend du repas. La vitamine C de l'orange (92,3 mg pour le repas, dont 71,3 mg pour l'orange) augmente l'absorption du fer non héminique ; il faut donc la consommer au même repas. Le thé et le café au repas la diminuent.

4. Déjeuner de viande : 36,7 g ; déjeuner végétarien : 25,8 g, soit 10,9 g de moins. C'est un apport tout à fait suffisant pour un déjeuner. L'association d'une légumineuse (lentilles) et d'une céréale (riz) apporte des acides aminés complémentaires (la lysine des lentilles et les acides aminés soufrés du riz) : la qualité des protéines est bonne.

5. Le riz a une teneur en fer inférieure à 0,25 mg pour 100 g : elle est comptée 0, donc le total est légèrement sous-estimé (au plus 0,4 mg de plus). Le sel calculé (0,1 g) ne tient pas compte du sel ajouté à la cuisson, qui n'est pas dans les aliments de la table.

6. Prendre un fruit cru ou des crudités au même repas que le plat de légumineuses ; éviter le thé ou le café juste après le repas ; prendre un produit laitier pour le calcium et les protéines ; varier les légumineuses dans la semaine.

Corrigé – Exercice 4.29

1. Halal : porc, vin rouge (alcool, même cuit) ; bœuf s'il n'est pas halal. Casher : porc ; mélange de la viande et des produits laitiers (béchamel, parmesan) ; viande non casher ; vin non casher. Végétarienne sans œufs : viande, pâtes aux œufs ; parmesan (fait avec de la présure animale). Végétalienne : viande, lait, beurre, parmesan, œufs des pâtes. Allergie aux fruits à coque : pesto aux pignons (les pignons ne sont pas des fruits à coque au sens réglementaire, mais le pesto en contient souvent : noix de cajou, et risque de traces) ; on le supprime par précaution.

2. Lasagnes aux lentilles et aux légumes : la viande est remplacée par des lentilles vertes et des légumes (carottes, courgettes, champignons), ce qui convient aux végétariens, aux personnes qui mangent halal et casher, et diminue le coût et l'empreinte carbone ; le vin est remplacé par un peu de vinaigre balsamique ou de concentré de tomate pour le goût ; pâtes à lasagnes sans œufs (blé dur seulement) ; béchamel préparée avec une boisson de soja enrichie en calcium et de l'huile d'olive, ce qui convient aussi à la personne végétalienne et à la règle casher de séparation viande-lait (de toute façon, le plat est sans viande) ; parmesan servi à part, pour ceux qui le souhaitent, ou remplacé par de la levure maltée ; décoration avec du basilic frais, sans pesto. On vérifie toutes les étiquettes (présence de traces de fruits à coque, de gélatine, d'alcool dans les arômes).

3. La cacheroute exige des produits certifiés et une cuisine et des ustensiles qui n'ont pas servi à des aliments non casher : un atelier ordinaire ne peut pas le garantir. On en parle avec la personne avant l'atelier : elle peut participer à la préparation et à la dégustation des ingrédients qu'elle accepte, apporter sa vaisselle, ou choisir de ne pas manger le plat ; c'est elle qui décide.

4. On présente une recette « lasagnes végétales pour tous », mise en avant pour son goût, son prix et sa simplicité, sans parler des religions ni désigner les personnes.

Corrigé – Exercice 4.30

1. Ramadan : 9 / 30 = 0,30 malaise par jour ; reste de l'année : 18 / 270 = 0,067 malaise par jour. Rapport : 0,30 / 0,0667 = 4,5. Il y a eu 4,5 fois plus de malaises par jour pendant le mois du Ramadan. (Les effectifs présents sont voisins, 128 et 132, ce qui permet de comparer les nombres par jour ; on peut aussi calculer 9 / 128 / 30 et 18 / 132 / 270 pour 1 000 apprentis-jours : 2,34 et 0,51, soit un rapport de 4,6.)

2. 46 / 140 × 100 = 32,9 % des apprentis.

3. Le manque de sommeil (lever à 5 h, puis repas tardifs) diminue la vigilance ; la déshydratation, surtout sur les chantiers où il fait chaud sous le casque, provoque fatigue, maux de tête et malaises ; la rupture très sucrée (pâtisseries) peut être suivie d'une baisse d'énergie, et un suhur trop léger ne tient pas jusqu'au soir. Un travail physique sans pouvoir boire augmente encore le risque.

4. Suhur : prendre un vrai repas avant l'aube plutôt que de le sauter, avec des féculents complets (pain complet, flocons d'avoine), une source de protéines (œufs, produit laitier, légumineuses) et un fruit, plus de l'eau. Rupture : commencer par boire de l'eau, une soupe (chorba) et quelques dattes, puis un repas complet, en limitant les fritures et les pâtisseries à une petite part. Hydratation : boire régulièrement entre la rupture et le suhur (environ 1,5 à 2 L), en évitant les boissons très sucrées et le café en grande quantité.

5. Organiser, pour tous les apprentis, pendant tout le mois, des pauses supplémentaires et un aménagement des tâches les plus physiques ou à risque (travail en hauteur, chaleur) l'après-midi ; proposer au restaurant du CFA un « repas à emporter » le soir à tout apprenti qui le demande, sans avoir à se justifier ; informer tous les apprentis et les maîtres d'apprentissage sur les signes de déshydratation et sur la conduite à tenir en cas de malaise. Ces mesures sont ouvertes à tous et ne désignent personne.

6. Le jeûne est dangereux en cas de diabète de type 1 (risque d'hypoglycémie sévère et d'acidocétose) : l'infirmière l'invite à en parler à son diabétologue avant le Ramadan. La religion prévoit des dispenses pour les personnes malades ; c'est le médecin qui donne un avis, pas le diététicien.

7. Le diététicien ne juge pas la pratique et ne cherche pas à la faire changer ; il aide la personne à la vivre en sécurité, sans supposer que quelqu'un jeûne du fait de son origine, et oriente vers le médecin en cas de maladie. Il respecte la confidentialité (« mon patron ne sait pas que je jeûne »).

Partie 6 – Les rythmes alimentaires et les âges de la vie

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer repas, collation, grignotage et prise nocturne.
- Calculer et interpréter la répartition de l'énergie dans la journée à l'aide des fourchettes usuelles.
- Argumenter sur la collation matinale à l'école et sur le petit-déjeuner à l'aide de données datées.
- Relier les comportements fréquents à chaque âge de la vie aux points d'attention de santé publique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Rythme alimentaire : nombre, horaires et régularité des prises. Repas : prise structurée, à heure régulière. Collation : prise prévue, en petite quantité, entre deux repas, en réponse à une faim. Grignotage : prises répétées, non structurées, sans faim.
- Répartition usuelle de l'énergie (ordres de grandeur, pas des normes) : petit-déjeuner 20 à 25 %, déjeuner 35 à 40 %, goûter 10 à 15 %, dîner 25 à 30 %. La régularité compte autant que la répartition.
- Collation matinale à l'école : non recommandée si l'enfant a pris un petit-déjeuner (avis de l'AFSSA, 2004).
- Chrononutrition : une alimentation concentrée en journée et un dîner pas trop tardif semblent plus favorables ; le travail posté ou de nuit augmente le risque de troubles métaboliques.
- Âges de la vie : adolescence (petit-déjeuner sauté, boissons sucrées, préoccupations corporelles), jeunes adultes (budget, repas sautés), actifs (temps, charge mentale du repas, souvent portée par les femmes), grossesse (folates, iode, fer, toxi-infections), personnes âgées (baisse de l'appétit, isolement, dénutrition).
- Dénutrition de la personne de 70 ans et plus (HAS, 2021) : parmi les critères, une perte de poids d'au moins 5 % en un mois ou d'au moins 10 % en six mois.

Exercice 4.31 – Légender la répartition de l'énergie dans la journée (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un atelier pour des parents d'élèves d'une école élémentaire sur le thème « les quatre repas de l'enfant ».

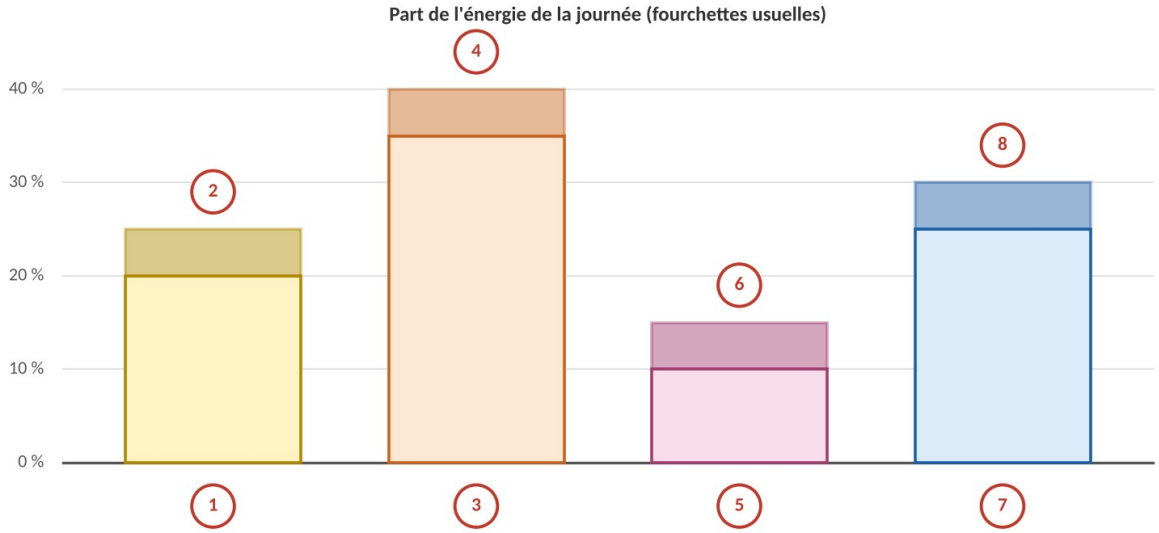


Figure 4.6 – Document 1 – Répartition usuelle de l'énergie dans la journée (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1 : le nom de chaque prise et sa fourchette. (4 pts)
2. Calculez la part de l'énergie apportée par le petit-déjeuner et le déjeuner ensemble (bornes basse et haute). (1 pt)
3. Expliquez pourquoi le goûter est une vraie prise chez l'enfant. (1,5 pt)
4. Expliquez pourquoi ces fourchettes ne sont pas des normes strictes. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.32 – La journée d'une étudiante en stage du matin (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Clara, étudiante en soins infirmiers, est en stage dans un service hospitalier, de 6 h 45 à 14 h 15. Elle se plaint d'avoir « tout le temps faim l'après-midi » et de grignoter jusqu'au soir. Elle a noté sa journée dans un carnet alimentaire.

Document 1 – Carnet alimentaire d'une journée de stage (énergie estimée avec Ciqual 2025)

Heure	Prise	Énergie
6 h 00	Café sans sucre, rien d'autre	0 kcal
9 h 30	Viennoiserie et jus de fruits à la cafétéria	380 kcal
14 h 30	Déjeuner au self de l'hôpital	820 kcal
17 h 00 à 19 h 30	Biscuits, chips, chocolat devant les révisions	420 kcal
21 h 00	Dîner	580 kcal

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie totale de la journée, puis la part de chaque prise (une décimale). Vérifiez que le total fait 100 %. (3 pts)
2. Calculez la part des prises non structurées (prise de 9 h 30 et grignotage) et comparez la journée aux fourchettes usuelles. (2 pts)
3. Expliquez le grignotage de l'après-midi à l'aide de la régulation et du rythme de Clara. (2 pts)
4. Proposez une nouvelle organisation de la journée, adaptée aux horaires du stage, sans augmenter l'énergie totale. Donnez l'heure et un exemple de chaque prise. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi on lui conseille de ne pas « compenser » en sautant le dîner. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Exercice 4.33 – Faut-il garder la collation de 10 h ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – argumentation · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une école élémentaire de 180 élèves distribue chaque matin, à 10 h, une collation à tous les enfants : un verre de jus d'orange (200 g) et deux biscuits secs (20 g en tout). La mairie, qui la finance, vous demande s'il faut la garder.

Document 1 – Données de l'école et de Ciqual 2025 (données de l'école fictives)

- Enquête auprès des familles (toutes ont répondu) : 27 enfants ne prennent pas de petit-déjeuner les jours d'école.
- Coût de la collation : 0,35 € par enfant et par jour ; 140 jours d'école par an.
- Jus d'orange, pur jus (code 2070) : 45,4 kcal et 9,61 g de sucres pour 100 g. Biscuit sec nature (code 24001) : 438 kcal et 25,4 g de sucres pour 100 g.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie et les sucres apportés par la collation. (2 pts)

2. Calculez la part des enfants qui ne prennent pas de petit-déjeuner, puis le coût annuel de la collation pour toute l'école. (2 pts)

3. Rappelez la position de l'AFSSA (2004) et expliquez pourquoi une collation à 10 h n'est pas utile à un enfant qui a pris un petit-déjeuner. (3 pts)

4. Proposez à la mairie une utilisation plus pertinente du même budget. (3 pts)

5. Indiquez comment éviter que les enfants sans petit-déjeuner soient montrés du doigt. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.34 – Trois petits-déjeuners de lycéens (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour une semaine « petit-déjeuner » au lycée, vous comparez trois petits-déjeuners relevés auprès d'élèves volontaires. Vous voulez montrer que l'énergie ne dit pas tout.

Document 1 – Trois petits-déjeuners et leurs apports (Ciqual 2025)

Petit-déjeuner	Composition	Énergie	Protéines	Fibres	Sucres	Lipides	Calcium
A	Céréales chocolatées enrichies 50 g, lait demi-écrémé 200 g, jus d'orange 200 g	à calculer	12,3 g	4,1 g	40,4 g	5,9 g	504 mg
B	Pain blanc 60 g, beurre 10 g, yaourt nature 125 g, kiwi 100 g	371,0 kcal	10,7 g	4,0 g	15,4 g	11,8 g	215 mg
C	Pain au chocolat artisanal 70 g, boisson énergisante sucrée 250 g	398,4 kcal	5,5 g	2,4 g	34,5 g	15,8 g	16 mg

Pour 100 g : céréales chocolatées enrichies (code 32001) 393 kcal ; lait demi-écrémé UHT (19041) 47,7 kcal ; jus d'orange pur jus (2070) 45,4 kcal.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie du petit-déjeuner A. (1,5 pt)
2. Calculez la part de chaque petit-déjeuner dans une journée de 2 000 kcal. Comparez à la fourchette usuelle. (1,5 pt)
3. Calculez la part de l'énergie apportée par les sucres dans chaque petit-déjeuner (1 g de sucres = 4 kcal). (2 pts)
4. Comparez les trois petits-déjeuners sur leur qualité nutritionnelle. Expliquez pourquoi le calcium de A est si élevé. (3 pts)
5. Indiquez ce qui pose problème dans le petit-déjeuner C, au-delà des nutriments, pour un lycéen. (1,5 pt)
6. Proposez une amélioration simple, peu coûteuse et rapide pour A et pour C. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.35 – Les comportements selon les âges de la vie (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) prépare un guide pour les professionnels de son territoire. Vous rédigez la partie « comportements alimentaires selon l'âge ».

Document 1 – Situations à classer

a) « Je n'ai plus faim et le poisson n'a plus de goût. Depuis que mon mari est parti, je ne cuisine plus. »

b) « Je mange dans le bus en allant au lycée, quand je mange. »

c) « Je fais les courses, les menus et la cuisine pour quatre, en plus de mon travail. Je n'en peux plus. »

d) « J'ai des nausées le matin et des envies de cornichons. »

e) « Premier appartement, le frigo est vide le 25 du mois. »

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque situation à une période de la vie. (2,5 pts)

2. Pour chaque situation, indiquez un point d'attention de santé publique. (5 pts)

3. Expliquez la notion de charge mentale alimentaire et la façon d'en tenir compte dans un conseil. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.36 – Le portage de repas à domicile (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le CCAS de Bellegarde (données fictives) livre chaque matin, vers 10 h, un plateau froid « déjeuner et dîner » à 60 personnes âgées de 75 à 94 ans vivant seules à domicile. Les livreurs remarquent que beaucoup de plateaux reviennent à moitié pleins. La responsable vous demande une analyse et des propositions.

Document 1 – Données du service (données fictives)

- Un plateau apporte en moyenne 1 400 kcal et 60 g de protéines (déjeuner et dîner).
- Une estimation des restes sur une semaine montre que les bénéficiaires consomment en moyenne 62 % du plateau.
- 23 bénéficiaires prennent tous leurs repas seuls ; 14 ont perdu au moins 5 % de leur poids en un mois ou au moins 10 % en six mois (relevé du service de soins à domicile).
- Poids moyen des bénéficiaires : 62 kg. Repère d'apport en protéines chez la personne âgée : environ 1 g par kilogramme et par jour (ESPEN, 2019).

Document 2 – Ce que disent des bénéficiaires

« Tout arrive en même temps, à 10 h, je n'ai pas faim. » « Le soir, c'est froid et c'est triste. » « La viande est dure, avec mon dentier je la laisse. » « C'est fade. » « Avant, je mangeais avec mon mari. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie et les protéines réellement consommées en moyenne, puis la part du repère en protéines couverte par le plateau consommé pour une personne de 62 kg. (3 pts)
2. Calculez la part des bénéficiaires qui mangent seuls et celle qui a perdu du poids. Indiquez ce que représente cette perte de poids. (2 pts)
3. Classez les causes des restes du document 2 en déterminants biologiques et sensoriels, sociaux et environnementaux. (3 pts)
4. Proposez quatre améliorations du service, chacune reliée à une cause. (4 pts)
5. Proposez une action qui agit sur la dimension sociale du repas. (2 pts)
6. Indiquez la conduite à tenir pour les 14 personnes qui ont perdu du poids. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 4.31

1. Légendes : 1 Petit-déjeuner ; 2 20 à 25 % ; 3 Déjeuner ; 4 35 à 40 % ; 5 Goûter ; 6 10 à 15 % ; 7 Dîner ; 8 25 à 30 %.
2. Borne basse : 20 + 35 = 55 % ; borne haute : 25 + 40 = 65 %. Le petit-déjeuner et le déjeuner apportent plus de la moitié de l'énergie de la journée.
3. L'écart entre le déjeuner (vers 12 h) et le dîner (vers 19 h 30) est long pour un enfant qui grandit et qui bouge ; le goûter, pris vers 16 h 30, répond à une vraie faim et évite le grignotage de fin d'après-midi.
4. Ce sont des ordres de grandeur utilisés en restauration collective et en éducation nutritionnelle. Les besoins et les habitudes varient selon l'âge, l'activité, les horaires de travail et la culture ; ce qui compte surtout, c'est la régularité et la qualité des prises.

Corrigé – Exercice 4.32

1. Total : 0 + 380 + 820 + 420 + 580 = 2 200 kcal. Parts : 6 h 0,0 % ; 9 h 30 : 380 / 2 200 × 100 = 17,3 % ; déjeuner 820 / 2 200 = 37,3 % ; grignotage 420 / 2 200 = 19,1 % ; dîner 580 / 2 200 = 26,4 %. Vérification : 0,0 + 17,3 + 37,3 + 19,1 + 26,4 = 100,1 %, soit 100 % aux arrondis près.
2. Prises non structurées : 380 + 420 = 800 kcal, soit 800 / 2 200 × 100 = 36,4 %. Le petit-déjeuner est absent (0 % au lieu de 20 à 25 %) ; le déjeuner (37,3 %) et le dîner (26,4 %) sont dans les fourchettes, mais le déjeuner arrive très tard (14 h 30) ; le grignotage (19,1 %) dépasse ce qu'apporterait un goûter (10 à 15 %).
3. Clara reste près de 8 heures sans vrai repas (de 6 h à 14 h 30), avec une seule prise sucrée à 9 h 30 ; elle arrive au déjeuner affamée et fatiguée. L'après-midi, la fatigue du lever très matinal, le stress des révisions et la disponibilité des biscuits (facteurs environnementaux et émotionnels) entraînent des prises sans faim, automatiques.
4. Exemple : 6 h, petit-déjeuner rapide (bol de lait ou yaourt à boire, pain ou flocons d'avoine, fruit), environ 400 kcal ; 10 h, pendant la pause du service, collation prévue (pain et fromage ou fruit et poignée d'amandes), environ 200 kcal ; 14 h 30, déjeuner au self, environ 750 kcal ; 17 h, goûter assis, loin des révisions (pain complet, chocolat, produit laitier), environ 250 kcal ; 20 h, dîner simple, environ 600 kcal. Total : 400 + 200 + 750 + 250 + 600 = 2 200 kcal.
5. Sauter le dîner relance le cycle : faim le soir, sommeil perturbé, grignotage, puis absence de faim le matin. Cette compensation est une forme de restriction ; elle désorganise les rythmes au lieu de les régulariser.

Corrigé – Exercice 4.33

1. Énergie : 200 × 45,4 / 100 + 20 × 438 / 100 = 90,8 + 87,6 = 178,4 kcal. Sucres : 200 × 9,61 / 100 + 20 × 25,4 / 100 = 19,2 + 5,1 = 24,3 g, soit l'équivalent de près de cinq morceaux de sucre de 5 g.
2. 27 / 180 × 100 = 15,0 % des enfants. Coût annuel : 180 × 0,35 × 140 = 8 820,00 €.
3. L'AFSSA (2004) a estimé que la collation matinale n'est pas justifiée pour les enfants qui ont pris un petit-déjeuner : elle arrive peu de temps après ce repas et peu avant le déjeuner. Elle ajoute de l'énergie sans répondre à une faim, diminue l'appétit au déjeuner et habitue à manger sans faim ; ici, elle apporte surtout des sucres.
4. Supprimer la collation pour tous et utiliser une partie du budget pour : des petits-déjeuners pédagogiques en classe une fois par période, avec les familles (pain, beurre, lait, fruit), pour donner envie de prendre un petit-déjeuner à la maison ; une collation adaptée (pain, fruit, produit laitier), dès l'arrivée à l'école, pour les enfants qui n'ont pas mangé ; des fontaines à eau ; un atelier pour les parents sur les petits-déjeuners rapides et peu coûteux. Par exemple, une collation pour 27 enfants coûterait 27 × 0,35 × 140 = 1 323,00 €, ce qui laisse 7 497,00 € pour les autres actions.
5. Proposer la collation du matin à tout enfant qui le souhaite, à l'accueil, de façon discrète, sans liste ni

appel nominatif ; en parler avec les familles de façon individuelle et confidentielle, sans les juger.

Corrigé – Exercice 4.34

1. A : 50 × 393 / 100 + 200 × 47,7 / 100 + 200 × 45,4 / 100 = 196,5 + 95,4 + 90,8 = 382,7 kcal.

2. A : 382,7 / 2 000 × 100 = 19,1 % ; B : 371,0 / 2 000 = 18,6 % ; C : 398,4 / 2 000 = 19,9 %. Les trois sont proches de la borne basse de la fourchette (20 à 25 %) et apportent presque la même énergie.

3. A : 40,4 × 4 / 382,7 × 100 = 42,2 % ; B : 15,4 × 4 / 371,0 × 100 = 16,6 % ; C : 34,5 × 4 / 398,4 × 100 = 34,6 %.

4. B est le plus équilibré : il associe un féculent, un produit laitier et un fruit, peu de sucres (16,6 % de l'énergie). A apporte un produit laitier et des protéines, mais beaucoup de sucres (42,2 % de l'énergie, dont près des trois quarts viennent du jus et du lait : 19,2 g et 9,9 g) ; son calcium est élevé grâce au lait (242 mg) et parce que les céréales sont enrichies en vitamines et minéraux (261 mg pour 50 g). C apporte presque la même énergie que les deux autres, mais très peu de protéines (5,5 g), de fibres (2,4 g) et de calcium (16 mg), beaucoup de lipides (15,8 g) et de sucres.

5. La boisson énergisante contient de la caféine, déconseillée chez les adolescents (troubles du sommeil, palpitations, anxiété) ; elle est souvent associée à l'image de la performance. Ce petit-déjeuner est aussi souvent acheté et mangé debout, en chemin.

6. A : remplacer les céréales chocolatées par des flocons d'avoine ou du pain, et le jus par un fruit entier (moins de sucres, plus de fibres). C : garder le pain au chocolat de temps en temps, mais remplacer la boisson énergisante par un verre de lait ou un yaourt à boire et ajouter un fruit (une banane se transporte facilement).

Corrigé – Exercice 4.35

1. a) personne âgée ; b) adolescent ; c) adulte active ; d) femme enceinte ; e) jeune adulte.

2. a) Baisse de l'appétit, du goût, isolement après un veuvage : risque de dénutrition, besoin de protéines et de convivialité (repas partagés, portage). b) Saut du petit-déjeuner et repas pris « en chemin » : apports en calcium et en fer, rythmes, prévention des TCA si l'adolescent restreint pour maigrir. c) Charge mentale alimentaire et fatigue : risque de repas simplifiés, de stress, de culpabilité. d) Nausées et envies de grossesse : apports en folates, iode et fer, prévention de la listériose et de la toxoplasmose, prise de poids adaptée. e) Précarité étudiante ou des jeunes travailleurs : repas sautés, compétences culinaires, recours aux aides.

3. La charge mentale alimentaire est le travail invisible de planification, de courses, de cuisine et de gestion des goûts de chacun, encore porté majoritairement par les femmes. Un conseil qui ajoute des tâches (« cuisinez tout maison ») aggrave cette charge. On privilégie des solutions qui simplifient : menus de la semaine, cuisine en avance, recettes rapides, participation des enfants et du conjoint.

Corrigé – Exercice 4.36

1. Énergie consommée : 1 400 × 0,62 = 868 kcal ; protéines : 60 × 0,62 = 37,2 g. Repère pour 62 kg : 62 × 1 = 62 g par jour ; le plateau consommé en couvre 37,2 / 62 × 100 = 60,0 %. Le petit-déjeuner et le goûter doivent apporter le reste, ce qui est difficile pour des personnes qui ont peu d'appétit.

2. Mangent seuls : 23 / 60 × 100 = 38,3 % ; perte de poids : 14 / 60 × 100 = 23,3 %. Une perte d'au moins 5 % en un mois ou d'au moins 10 % en six mois est l'un des critères de diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus (HAS, 2021).

3. Biologiques et sensoriels : pas de faim à 10 h (absence de faim au moment de la livraison), mastication difficile avec le dentier (« la viande est dure »), baisse du goût (« c'est fade »). Sociaux : solitude (« avant, je mangeais avec mon mari »). Environnementaux : livraison unique du déjeuner et du dîner le matin, plat du soir froid (« c'est froid et c'est triste »).

4. Proposer des viandes tendres, hachées ou mijotées, et des alternatives (œufs, poisson, produits laitiers)

pour les personnes qui mâchent mal ; relever le goût avec des herbes, des épices, des sauces, et proposer des plats choisis par les bénéficiaires (menu à choix) ; prévoir un plat chaud facile à réchauffer pour le soir et conseiller le moment de chaque prise ; enrichir les préparations (fromage râpé, œuf, lait en poudre) et ajouter un dessert lacté, pour augmenter les protéines sans augmenter le volume ; fractionner en proposant une collation (fromage, compote, gâteau de riz) dans le plateau.

5. Organiser un repas partagé une fois par semaine dans une salle du CCAS, avec transport accompagné ; ou associer le portage à une visite de bénévoles qui partagent un café et le dessert ; ou mettre en relation des voisins pour des repas ensemble.

6. Signaler ces personnes, avec leur accord, au médecin traitant pour une évaluation de la dénutrition ; renforcer la surveillance (pesée mensuelle par le service de soins, suivi des restes) ; envisager une prise en charge diététique individuelle et, si besoin, des compléments nutritionnels oraux prescrits par le médecin.

Partie 7 – Le comportement alimentaire de l'enfant

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire les grandes étapes du développement du comportement alimentaire, de la succion aux morceaux.
- Expliquer la néophobie alimentaire et l'intérêt de l'exposition répétée sans pression.
- Utiliser le partage des responsabilités (Satter) pour conseiller des parents et des professionnels de la petite enfance.
- Calculer et interpréter l'évolution d'un taux d'acceptation au fil des expositions.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Diversification alimentaire entre 4 mois révolus et 6 mois (Santé publique France, 2021), avec introduction des allergènes majeurs (œuf, arachide, gluten…) sans retard ; pas de sel ajouté ; pas de lait de vache comme boisson principale ni de miel avant 1 an.
- Textures : purées lisses, puis moulinées et écrasées, petits morceaux fondants vers 8 à 10 mois ; alimentation proche de celle de la famille entre 1 et 3 ans.
- Néophobie alimentaire : refus des aliments nouveaux, maximal entre 2 et 6 ans ; il faut souvent 8 à 15 expositions, sans pression, pour qu'un enfant accepte un aliment.
- Partage des responsabilités (Ellyn Satter) : le parent décide quoi, quand et où ; l'enfant décide s'il mange et combien. La pression (« finis ton assiette »), la récompense et la restriction perturbent la régulation.
- Le goût est un apprentissage : arômes du liquide amniotique et du lait maternel, exposition, imitation, contexte émotionnel ; les aversions conditionnées peuvent durer toute la vie.

Exercice 4.37 – Légender le développement du comportement alimentaire (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une puéricultrice de protection maternelle et infantile (PMI) vous demande une frise simple pour les parents qui attendent en salle d'attente.

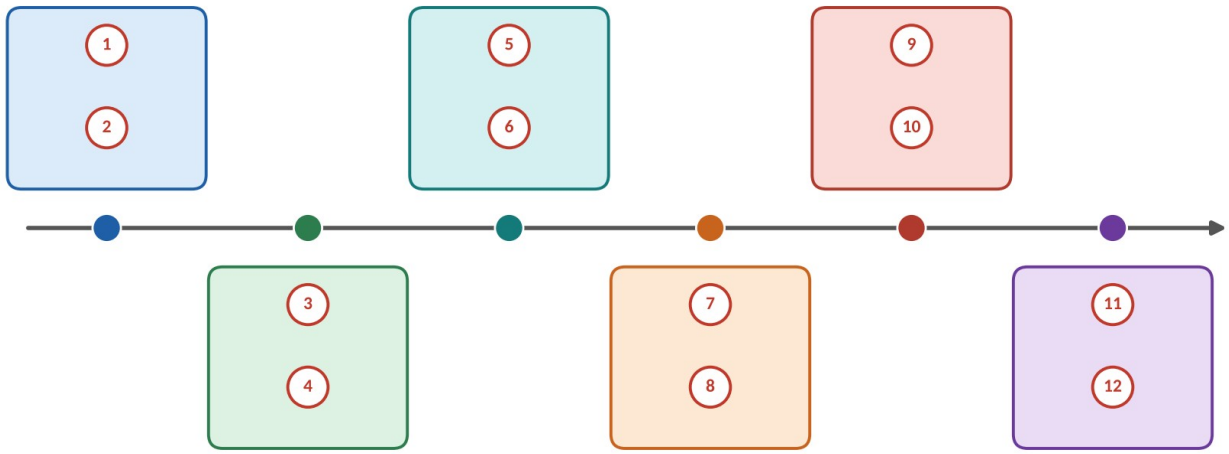


Figure 4.7 – Document 1 – Le développement du comportement alimentaire de l'enfant (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1 : la période et ce qui la caractérise. (6 pts)

2. Indiquez, pour deux périodes, le rôle de l'entourage. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.38 – Légender le partage des responsabilités (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un groupe de parents dans un centre social. Plusieurs parents racontent que les repas sont devenus « une bataille ».

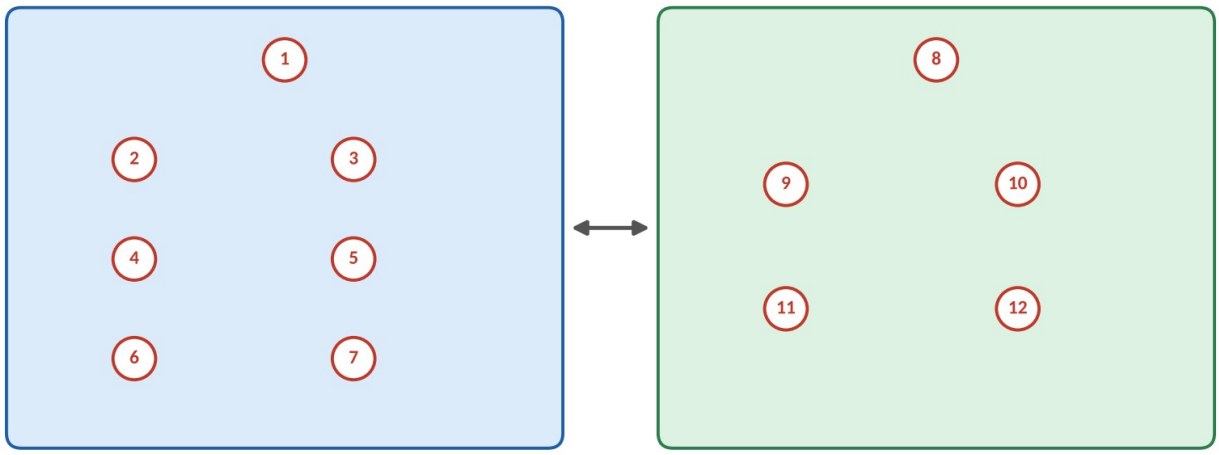


Figure 4.8 – Document 1 – Le partage des responsabilités dans l'alimentation de l'enfant (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (6 pts)

2. Citez l'auteure de ce modèle et sa profession. (1 pt)

3. Expliquez en quoi ce modèle protège la régulation de la faim et de la satiété de l'enfant. (2 pts)

4. Expliquez en quoi il peut soulager les parents. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.39 – Faire accepter la courge à la cantine maternelle (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cantine d'une école maternelle (48 enfants de 3 à 5 ans) a proposé de la courge butternut une fois par semaine pendant 10 semaines, sous des formes variées (purée, soupe, gratin, frites au four, gâteau). Les agents ont noté chaque semaine le nombre d'enfants qui ont goûté au moins une bouchée. Aucun enfant n'a été obligé.

Document 1 – Nombre d'enfants qui goûtent (sur 48, données fictives)

Semaine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Enfants qui goûtent	10	13	15	19	22	25	29	31	33	34

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage d'enfants qui goûtent aux semaines 1, 5 et 10, puis le gain en points entre la semaine 1 et la semaine 10. (3 pts)
2. Indiquez à partir de quelle semaine plus de la moitié des enfants goûtent. Justifiez par le calcul. (1 pt)
3. Calculez l'augmentation moyenne du nombre d'enfants qui goûtent par semaine. (1 pt)
4. Expliquez ces résultats à l'aide de la néophobie et de l'exposition répétée. (2 pts)
5. Indiquez deux limites de ces données. (2 pts)
6. Proposez trois façons d'associer les familles et l'équipe pour aller plus loin. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.40 – Ce que disent les parents à table (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors de l'atelier parents-enfants, vous avez noté des phrases dites par les parents. Vous voulez les utiliser pour un jeu « on garde ou on change ? ».

Document 1 – Phrases de parents

a) « Tu ne sors pas de table tant que tu n'as pas fini. »

b) « Ce soir, il y a des haricots verts et des pâtes ; tu prends ce que tu veux dans ce qui est servi. »

c) « Si tu manges ta soupe, tu auras du chocolat. »

d) « On mange à 19 h, tous ensemble, la télé éteinte. »

e) « Tu n'as plus faim ? D'accord, tu peux sortir de table. »

f) « Pas de dessert, tu as déjà trop mangé, tu vas grossir. »

g) « Goûte juste une petite bouchée ; si tu n'aimes pas, tu laisses. »

h) « Je lui fais un plat à part, il ne mange que des pâtes. »

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque phrase : elle respecte le partage des responsabilités (« on garde ») ou elle ne le respecte pas (« on change »). (4 pts)
2. Pour chaque phrase « on change », expliquez le problème et proposez une reformulation. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi utiliser un aliment comme récompense augmente son attrait. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.41 – Vrai ou faux sur la diversification (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – connaissances appliquées · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une assistante maternelle qui garde trois bébés vous pose des questions sur la diversification. Elle a entendu beaucoup de conseils contradictoires et vous montre ce qu'elle a noté.

Document 1 – Ce qu'elle a entendu

a) « Il faut attendre 1 an pour donner de l'œuf, pour éviter les allergies. »

b) « On peut commencer la diversification entre 4 mois révolus et 6 mois. »

c) « Un peu de miel dans le yaourt de 8 mois, c'est bon pour la gorge. »

d) « Il ne faut pas saler les purées des bébés. »

e) « Si un bébé refuse les épinards deux fois, c'est qu'il ne les aime pas : on arrête. »

f) « Vers 8 à 10 mois, on peut proposer de petits morceaux fondants. »

g) « Les cacahuètes entières, c'est une bonne façon d'introduire l'arachide à 9 mois. »

h) « Le lait de vache peut remplacer le lait infantile dès 6 mois. »

À vous de jouer – Questions

1. Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse, et corrigez les affirmations fausses en citant la source (Santé publique France, 2021). (8 pts)
2. Proposez deux conseils pour respecter la régulation du bébé pendant le repas. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.42 – Former les assistantes maternelles du relais petite enfance (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le relais petite enfance (RPE) de la communauté de communes du Val-Fleuri (données fictives) accompagne 36 assistantes maternelles qui accueillent environ 100 enfants de moins de 6 ans. L'animatrice du relais constate que les repas sont souvent source de tensions entre assistantes maternelles, enfants et parents. Elle vous demande un diagnostic et un programme de formation de trois matinées.

Document 1 – Questionnaire rempli par les 36 assistantes maternelles (données fictives)

Pratique déclarée	Nombre
Demande à l'enfant de finir son assiette	21
Utilise le dessert comme récompense	15
Propose un aliment refusé une seule fois, puis abandonne	24
Laisse un écran allumé pendant les repas	6
Souhaite une formation sur l'alimentation	29

Document 2 – Ce que disent des assistantes maternelles

« Les parents me demandent combien il a mangé ; si l'assiette n'est pas vide, ils pensent que je ne m'en occupe pas. » « Le petit Noé ne mange que du blanc : riz, pâtes, pain. » « Je fais comme on m'a appris, on ne gaspille pas. » « Avec quatre enfants à table, je n'ai pas le temps. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de chaque pratique. (2,5 pts)
2. Analysez les pratiques et les contraintes des assistantes maternelles à l'aide de trois notions du cours. (4 pts)
3. Formulez l'objectif général et deux objectifs opérationnels de la formation. (2 pts)
4. Proposez le contenu des trois matinées (thème, méthode active, support). (4,5 pts)
5. Proposez un outil pour répondre à l'inquiétude des parents sur ce que l'enfant a mangé. (1,5 pt)
6. Indiquez la conduite à tenir pour Noé. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 4.37

1. Légendes : 1 0-6 mois ; 2 lait maternel ou infantile ; régulation à la demande ; 3 4-6 mois ; 4 début de la diversification, purées lisses ; 5 8-10 mois ; 6 petits morceaux fondants, mastication ; 7 1-3 ans ; 8 repas proche de la famille, autonomie à la cuillère ; 9 2-6 ans ; 10 néophobie maximale : exposition répétée sans pression ; 11 6-11 ans ; 12 ouverture, influence de l'école et des pairs.
2. 0-6 mois : repérer les signes de faim et de satiété du bébé, soutenir l'allaitement, nourrir à la demande. 1-3 ans : partager les repas en famille, montrer l'exemple, garder des horaires réguliers, laisser l'enfant manger seul. 2-6 ans : proposer sans forcer, plusieurs fois, sous des formes variées. 6-11 ans : cuisiner ensemble, éducation sensorielle, lien avec la cantine.

Corrigé – Exercice 4.38

1. Légendes : 1 Le parent décide ; 2 quoi ; 3 une offre variée et adaptée ; 4 quand ; 5 des horaires réguliers ; 6 où ; 7 un cadre agréable, à table, sans écran ; 8 L'enfant décide ; 9 s'il mange ; 10 selon sa faim, sans être forcé ; 11 combien ; 12 sans récompense ni punition.
2. Ellyn Satter, diététicienne américaine.
3. L'enfant naît avec une bonne capacité à réguler ce qu'il mange selon sa faim. Si on le laisse décider de la quantité, il continue d'écouter ses signaux internes. La pression pour finir, la récompense ou l'interdiction lui apprennent au contraire à manger pour faire plaisir à l'adulte ou à cause d'une règle, ce qui affaiblit la régulation et augmente l'attrait des aliments interdits.
4. Le parent n'a plus à « réussir » à faire manger son enfant : son rôle est de proposer une offre de qualité dans un cadre agréable. Si l'enfant mange peu à un repas, ce n'est pas un échec ; il compensera souvent au repas suivant.

Corrigé – Exercice 4.39

1. Semaine 1 : 10 / 48 × 100 = 20,8 % ; semaine 5 : 22 / 48 = 45,8 % ; semaine 10 : 34 / 48 = 70,8 %. Gain : 70,8 − 20,8 = 50,0 points.
2. Semaine 5 : 22 / 48 = 45,8 % ; semaine 6 : 25 / 48 = 52,1 %. Plus de la moitié des enfants goûtent à partir de la semaine 6, soit la 6e exposition.
3. (34 − 10) / 9 = 24 / 9 = 2,7 enfants de plus par semaine en moyenne (9 intervalles entre la semaine 1 et la semaine 10).
4. Entre 3 et 5 ans, les enfants refusent souvent les aliments nouveaux (néophobie). À chaque présentation, la courge devient plus familière ; sans pression, le refus diminue et la curiosité l'emporte. Il a fallu 6 expositions pour dépasser la moitié des enfants et 10 pour atteindre 70,8 %, ce qui correspond aux 8 à 15 expositions souvent nécessaires. Les formes variées (frites au four, gâteau) ont pu faciliter l'acceptation.
5. « Goûter une bouchée » ne veut pas dire aimer ni manger une portion ; les comptages sont faits par des agents différents, sans grille commune ; les enfants ne sont pas toujours les mêmes (absences) ; il n'y a pas de groupe de comparaison (les enfants grandissent, ils ont pu goûter la courge à la maison).
6. Informer les familles par une affiche et un message (« cette semaine, la courge sous forme de… »), avec une recette simple à refaire à la maison ; faire manger les adultes de la cantine avec les enfants et goûter devant eux (modèle) ; organiser un atelier sensoriel en classe (toucher, sentir, nommer la courge, la planter) avec l'enseignante ; utiliser une échelle de goût en smileys pour recueillir l'avis des enfants.

Corrigé – Exercice 4.40

1. On garde : b), d), e), g). On change : a), c), f), h).
2. a) Forcer à finir apprend à manger sans faim et associe le repas à une contrainte. Reformulation : « Tu as

assez mangé ? Tu peux sortir de table ; le prochain repas sera au goûter. » c) La récompense valorise le chocolat et dévalorise la soupe (« elle doit être mauvaise, puisqu'on me paie pour la manger »). Reformulation : « Il y a de la soupe ce soir ; goûte, tu me diras ce que tu sens. » Le dessert est servi normalement. f) L'interdit lié au poids crée de la culpabilité et de l'insatisfaction corporelle, et augmente l'attrait du dessert. Reformulation : « Le dessert fait partie du repas, on le prend tous ensemble. » (Le parent choisit le dessert et sa portion.) h) Faire un plat à part enferme l'enfant dans ses préférences et supprime les occasions de découvrir. Reformulation : « Ce soir, il y a du poisson, des carottes et du pain ; tu prends ce que tu veux dans ce qui est servi. » On place toujours sur la table au moins un aliment qu'il aime.

3. L'aliment donné en récompense est associé à un moment positif et à une valeur supérieure ; il devient plus désirable. À l'inverse, l'aliment qu'il « faut » manger pour obtenir la récompense est perçu comme une corvée.

Corrigé – Exercice 4.41

1. a) Faux : les allergènes majeurs, dont l'œuf, s'introduisent sans retard, dès le début de la diversification, entre 4 et 6 mois ; retarder ne protège pas des allergies (Santé publique France, 2021). b) Vrai. c) Faux : pas de miel avant 1 an, en raison du risque de botulisme infantile. d) Vrai : on n'ajoute pas de sel aux préparations des bébés. e) Faux : un refus est normal ; il faut souvent 8 à 15 présentations, sans forcer, pour qu'un enfant accepte un aliment. f) Vrai. g) Faux : les fruits à coque et les cacahuètes entières sont interdits avant 4 à 5 ans (risque d'étouffement) ; on introduit l'arachide sous forme de poudre ou de purée lisse mélangée à une préparation. h) Faux : le lait de vache n'est pas adapté comme boisson lactée avant 1 an ; on garde le lait maternel ou le lait infantile (deuxième âge après la diversification).

2. Repérer les signes de faim (bouche ouverte, agitation) et de satiété (tête tournée, bouche fermée, jeu avec la nourriture) et s'arrêter quand le bébé n'a plus faim ; proposer sans forcer et sans « dernière cuillère » ; installer le bébé au calme, face à l'adulte, sans écran.

Corrigé – Exercice 4.42

1. Finir son assiette : 21 / 36 × 100 = 58,3 % ; dessert en récompense : 15 / 36 = 41,7 % ; abandon après un refus : 24 / 36 = 66,7 % ; écran pendant les repas : 6 / 36 = 16,7 % ; souhaite une formation : 29 / 36 = 80,6 %.

2. Partage des responsabilités : demander de finir l'assiette (58,3 %) et récompenser avec le dessert (41,7 %) empiètent sur la part de l'enfant (combien, s'il mange) et perturbent sa régulation. Néophobie et exposition répétée : abandonner un aliment après un seul refus (66,7 %) prive l'enfant des 8 à 15 expositions nécessaires ; Noé, qui « ne mange que du blanc », illustre une sélectivité fréquente à cet âge. Normes et socialisation de l'adulte : « on ne gaspille pas », « je fais comme on m'a appris » ; à cela s'ajoute la pression des parents, qui jugent la qualité de l'accueil à l'assiette vide, et la contrainte de temps avec plusieurs enfants. Facteurs environnementaux : l'écran (16,7 %) détourne l'attention des signaux de faim et de satiété.

3. Objectif général : améliorer les pratiques d'accompagnement des repas des assistantes maternelles du relais pour respecter la régulation et favoriser la diversité alimentaire des enfants. Objectifs opérationnels : d'ici fin juin 2027, 24 assistantes maternelles au moins (sur 36) auront suivi les trois matinées de formation ; d'ici fin juin 2027, chaque participante aura testé avec ses parents employeurs le carnet de repas (question 5).

4. Matinée 1, « faim, satiété et partage des responsabilités » : photolangage sur les souvenirs de repas de l'enfance, présentation du schéma de Satter, jeu « on garde ou on change ? » sur des phrases du quotidien (support : schéma et cartes). Matinée 2, « néophobie et exposition répétée » : atelier sensoriel où les adultes goûtent les yeux bandés, analyse de cas (Noé), construction d'un calendrier de présentation d'un légume sur 10 semaines (support : fiche « 10 façons de présenter un légume »). Matinée 3, « organiser le repas à plusieurs enfants et parler avec les parents » : jeu de rôle d'un échange

avec un parent inquiet, préparation collective d'un repas adapté aux textures selon l'âge, présentation du carnet de repas (support : carnet et affiche « à table, sans écran »).

5. Un carnet de liaison qui décrit, plutôt que la quantité vidée, ce qui a été proposé, ce que l'enfant a goûté, son appétit (smiley) et l'ambiance du repas ; accompagné d'une affiche du relais qui explique aux parents le partage des responsabilités.

6. La sélectivité est fréquente entre 2 et 6 ans : on continue de proposer, sans forcer, les autres aliments à côté d'un aliment qu'il accepte, sous des formes variées, et l'on évite de lui préparer un plat à part. Si sa courbe de croissance se casse, s'il perd du poids ou si la sélectivité est très restreinte et durable, on conseille aux parents d'en parler à leur médecin (repérage d'un éventuel ARFID).

Partie 8 – Observer, mesurer et agir pour une alimentation durable

Objectifs – Objectifs de la partie

- Choisir un outil d'observation ou de mesure des comportements alimentaires adapté à une question et à un public, et en connaître les limites.
- Classer des aliments selon la classification NOVA et situer le débat sur l'ultra-transformation.
- Définir l'alimentation durable (FAO, 2010) et calculer l'empreinte carbone et le coût d'un plan de menus.
- Exploiter une échelle hédonique, un test triangulaire et une pesée des restes.
- Traiter un cas complet au format de l'épreuve.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Outils : rappel des 24 heures, carnet alimentaire (3 à 7 jours), questionnaire de fréquence, questionnaires de comportement (TFEQ, DEBQ), observation directe, pesée des restes. Chacun a ses limites (une seule journée, modification du comportement, imprécision des quantités, effet de l'observateur, pas d'information individuelle).
- NOVA (Monteiro) : groupe 1, aliments pas ou peu transformés ; groupe 2, ingrédients culinaires transformés ; groupe 3, aliments transformés ; groupe 4, produits ultra-transformés. Le Nutri-Score mesure la qualité nutritionnelle, pas le degré de transformation.
- Alimentation durable (FAO, 2010) : protège la biodiversité et les écosystèmes, est acceptable culturellement, accessible, économiquement équitable et abordable, nutritionnellement sûre et saine, et optimise l'usage des ressources.
- Ordres de grandeur d'empreinte carbone par portion (Agribalyse, ADEME, valeurs arrondies du cours) : bœuf 2,8 kg équivalent CO2 ; volaille 0,6 kg ; œufs 0,3 kg ; lentilles 0,06 kg.
- Échelle hédonique (notes de 1 à 5) ; taux d'acceptation = part des notes 4 et 5. Test triangulaire : trois échantillons dont deux identiques ; au hasard, une chance sur trois de trouver l'intrus ; seuils de la norme ISO 4120 (au risque de 5 % : 13 bonnes réponses sur 24, 15 sur 30).
- Loi EGalim (2018) : au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits biologiques, en restauration collective publique ; menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire ; diagnostic du gaspillage alimentaire.

Exercice 4.43 – Légender les outils d'observation et choisir le bon (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous travaillez avec une équipe de santé publique d'une collectivité qui veut mieux connaître les comportements alimentaires de plusieurs publics.

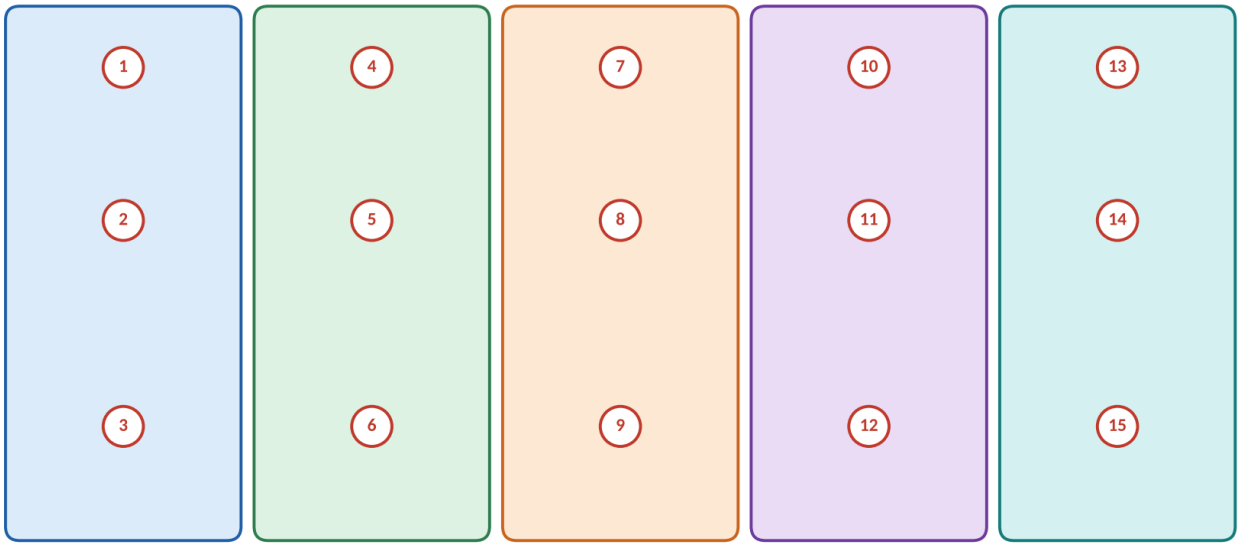


Figure 4.9 – Document 1 – Les outils d'observation et de mesure des comportements alimentaires (schéma à légender)

Document 2 – Les questions de l'équipe

a) Quelle part du repas les enfants de la cantine laissent-ils dans l'assiette ?

b) Comment se passe le goûter au centre de loisirs : ambiance, durée, interactions avec les animateurs ?

c) À quelle fréquence les adultes d'un quartier mangent-ils des légumes secs ?

d) Qu'a mangé hier, en détail, une personne âgée vue à domicile ?

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 15 du document 1 : le nom de l'outil, son principe et sa limite. (6 pts)
2. Choisissez l'outil le plus adapté à chaque question du document 2 et justifiez en une phrase. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.44 – Classer des produits selon NOVA (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier « lire les étiquettes » d'une épicerie solidaire, vous proposez aux participants de classer des produits du magasin selon leur degré de transformation.

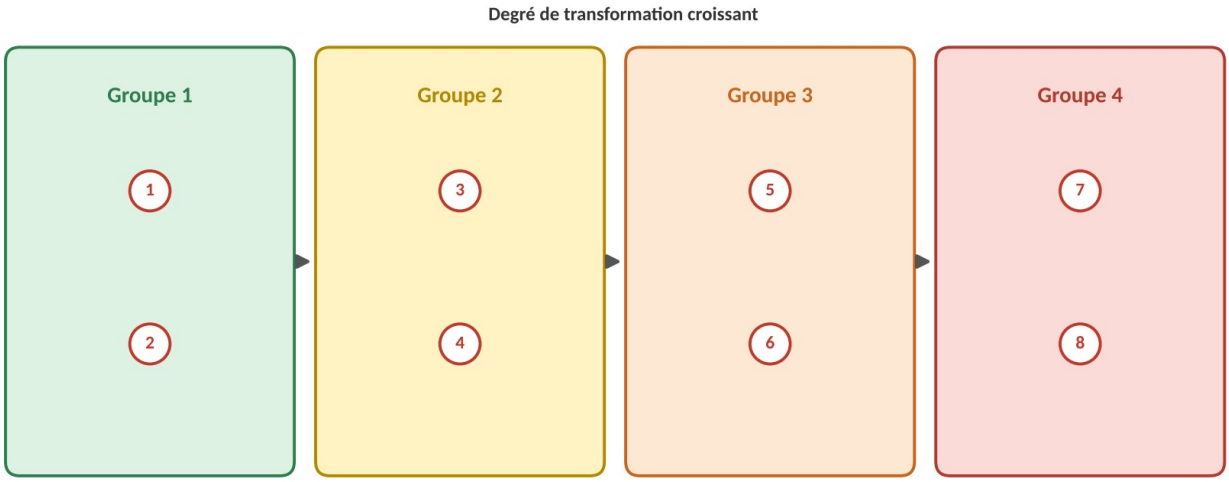


Figure 4.10 – Document 1 – La classification NOVA (schéma à légender)

Document 2 – Produits à classer

a) Lentilles vertes sèches. b) Huile de colza. c) Pain de mie industriel avec émulsifiants et conservateur. d) Haricots verts en conserve (haricots, eau, sel). e) Nuggets de poulet surgelés avec arômes et amidon modifié. f) Lait demi-écrémé. g) Fromage (lait, sel, ferments, présure). h) Soda aux édulcorants. i) Sucre en poudre. j) Yaourt aux fruits avec arôme, épaississant et colorant.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Classez les produits du document 2 dans les groupes NOVA. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi un produit peut avoir un bon Nutri-Score tout en étant ultra-transformé. (1,5 pt)
4. Rédigez un message prudent sur les produits ultra-transformés, qui tienne compte de l'état des connaissances et du budget des participants. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.45 – L'empreinte carbone des menus d'un collège (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de restauration d'un collège de 400 demi-pensionnaires prépare son plan de menus de quatre semaines (20 déjeuners). Le gestionnaire vous demande de comparer le plan actuel et un plan modifié, sur l'empreinte carbone et sur le coût du plat protidique.

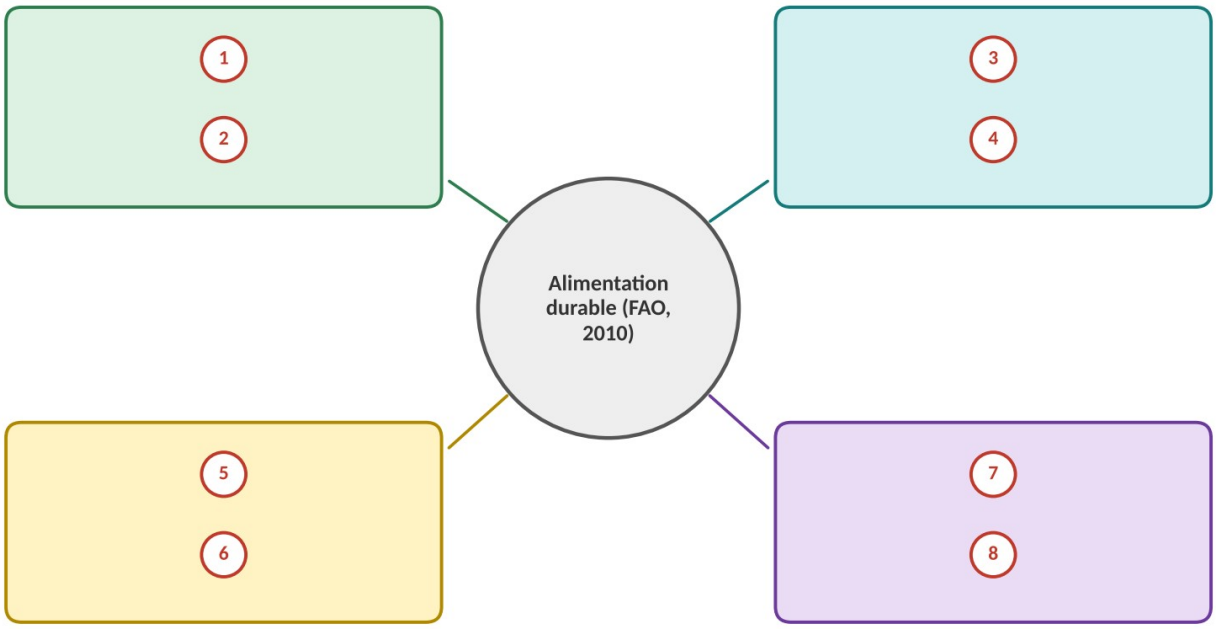


Figure 4.11 – Document 1 – Les dimensions de l'alimentation durable (schéma à légender)

Document 2 – Plats protidiques des 20 déjeuners et données par portion

Source de protéines	Plan actuel	Plan modifié	Empreinte par portion	Coût par portion (fictif)
Bœuf	6	2	2,8 kg éq. CO2	0,89 €
Volaille	6	6	0,6 kg éq. CO2	0,75 €
Œufs	4	4	0,3 kg éq. CO2	0,56 €
Légumineuses	4	8	0,06 kg éq. CO2	0,16 €

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (3 pts)
2. Calculez l'empreinte carbone des plats protidiques par élève sur quatre semaines pour chaque plan, puis la réduction en kg et en %. (3 pts)
3. Calculez la réduction pour les 400 élèves. (1 pt)
4. Calculez le coût des plats protidiques par élève pour chaque plan, puis l'économie pour les 400 élèves. (3 pts)
5. Le plan modifié respecte-t-il l'obligation d'un menu végétarien par semaine ? Justifiez. (1 pt)
6. Proposez deux usages de l'économie réalisée qui renforcent une autre dimension de l'alimentation durable. (2 pts)
7. Indiquez deux conditions pour que les élèves acceptent ces plats. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.46 – Une dégustation pour valider deux recettes (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association d'aide alimentaire veut intégrer deux recettes à son livret : un velouté de pois cassés et une compote de pommes avec 25 % de sucre en moins. Vous organisez une dégustation.

Document 1 – Échelle hédonique du velouté de pois cassés (24 participants, données fictives)

Note	5 (j'aime beaucoup)	4	3	2	1 (je n'aime pas du tout)
Nombre de participants	5	9	6	3	1

Document 2 – Test triangulaire sur la compote (30 participants, données fictives)

Chaque participant reçoit trois coupelles : deux de compote habituelle et une de compote avec 25 % de sucre en moins, ou l'inverse. 13 participants trouvent l'échantillon différent.

À vous de jouer – Questions

1. Vérifiez l'effectif, puis calculez la note moyenne du velouté (deux décimales). (2 pts)
2. Calculez le taux d'acceptation (notes 4 et 5) et le taux de rejet (notes 1 et 2). (2 pts)
3. Déterminez la note médiane. (1 pt)
4. Calculez le nombre de bonnes réponses attendues par le seul hasard dans le test triangulaire, puis le pourcentage de bonnes réponses obtenu. (2 pts)
5. Concluez sur le test triangulaire en utilisant le seuil de la norme ISO 4120 pour 30 participants. (2 pts)
6. Indiquez si les deux recettes peuvent entrer dans le livret et ce que vous feriez des remarques des participants qui ont noté 1 ou 2. (2 pts)
7. Citez une précaution d'hygiène et une précaution liée aux allergies pour la dégustation. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.47 – La pesée des restes au self (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre du diagnostic du gaspillage alimentaire prévu par la loi EGalim (2018), un collège a pesé les restes de 320 déjeuners pendant une journée, par composante du repas.

Document 1 – Résultats de la pesée (données fictives)

Composante	Portion servie	Quantité servie (320 repas)	Restes
Entrée de crudités	80 g	25,6 kg	9,2 kg
Plat protidique	100 g	32,0 kg	4,8 kg
Légumes	150 g	48,0 kg	21,6 kg
Féculents	150 g	48,0 kg	6,2 kg
Fruit	120 g	38,4 kg	13,4 kg
Pain	30 g	9,6 kg	3,1 kg

À vous de jouer – Questions

1. Vérifiez la quantité servie pour les légumes. Calculez la part des restes pour chaque composante (une décimale) et classez les composantes de la plus gaspillée à la moins gaspillée. (4 pts)
2. Calculez la quantité totale servie, les restes totaux, la part totale des restes et les restes par repas (en g). (2 pts)
3. Proposez trois hypothèses qui expliquent le gaspillage des légumes et des fruits, en lien avec le comportement alimentaire des adolescents. (2 pts)
4. Proposez trois actions qui réduisent le gaspillage sans diminuer la qualité nutritionnelle des repas. (3 pts)
5. Indiquez une limite de la pesée des restes et l'outil complémentaire que vous utiliseriez. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.48 – Cas complet : les repas à la maison d'enfants (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 1 h 45*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes diététicien en stage dans une association de protection de l'enfance. La maison d'enfants à caractère social (MECS) « Les Peupliers » (données fictives) accueille 42 jeunes de 6 à 17 ans, confiés par l'aide sociale à l'enfance, répartis en cinq groupes de vie. Les repas sont préparés par la cuisine de l'établissement et pris dans chaque groupe de vie, avec les éducateurs. La directrice constate des tensions pendant les repas, beaucoup de restes, et des jeunes qui stockent de la nourriture dans leur chambre. Elle dispose d'un budget de 1 800 € pour l'année et vous demande un diagnostic et un projet.

Document 1 – Observation de 20 repas avec une grille (données fictives)

Élément observé	Nombre de repas
Un éducateur est assis à table et mange avec les jeunes	7
Conflit autour de la nourriture (refus, menace, punition)	9
Repas de moins de 15 minutes	12
Téléphones à table	11

Document 2 – Questionnaire anonyme des jeunes (38 répondants sur 42, données fictives)

Réponse	Nombre de jeunes
Saute le petit-déjeuner au moins 3 jours par semaine	17
Garde de la nourriture dans sa chambre pour la nuit	14
Mange quand il est triste ou en colère	20
N'aime pas la plupart des plats servis	23
Aimerait cuisiner avec les éducateurs	29

Document 3 – Pesée des restes sur une semaine

588 repas servis (déjeuners et dîners), 294 kg servis, 88,2 kg de restes.

Document 4 – Ce que disent des jeunes et des éducateurs

Une jeune de 14 ans : « Chez ma mère, il n'y avait pas toujours à manger, alors je garde des gâteaux, on ne sait jamais. » Un jeune de 9 ans : « Je ne connais pas ces légumes, c'est pas comme chez moi. » Un éducateur : « Si un jeune ne mange pas, je lui dis qu'il n'aura pas de dessert. » Une éducatrice : « On n'a pas le droit de manger le même repas, alors je surveille debout. » Un jeune de 16 ans : « Le week-end, chez mon père, on mange du riz au poisson et c'est la fête. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez : le pourcentage de chaque élément observé (document 1) ; le taux de réponse et le pourcentage de chaque réponse (document 2) ; la part des restes, les restes par repas en grammes et la portion moyenne servie (document 3). (5 pts)
2. Analysez la situation des repas à l'aide de quatre notions du chapitre : rôles de l'acte alimentaire (notamment psychologique et affectif), alimentation émotionnelle et stratégies liées au manque, partage des responsabilités, néophobie et identité culturelle. Appuyez-vous sur des éléments précis des

documents. (7 pts)

3. Présentez sous forme de tableau les déterminants du comportement alimentaire des jeunes, classés en six familles, avec pour chacun un élément des documents. (5 pts)

4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et deux objectifs opérationnels du projet. (4 pts)

5. Proposez un plan de quatre actions, chacune justifiée par une notion du chapitre et adaptée à l'âge des jeunes. (8 pts)

6. Établissez un budget qui respecte les 1 800 €. (3 pts)

7. Proposez la démarche d'évaluation : indicateurs de processus et de résultats, outils et calendrier. (4 pts)

8. Indiquez les règles éthiques et la posture professionnelle à respecter avec ces jeunes et avec l'équipe. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 4.43

1. Légendes : 1 Rappel des 24 heures ; 2 entretien sur tout ce qui a été mangé la veille ; 3 précis, mais une seule journée ; 4 Carnet alimentaire ; 5 noter tout ce qui est consommé pendant 3 à 7 jours ; 6 modifie le comportement, contraignant ; 7 Questionnaire de fréquence ; 8 fréquence habituelle de groupes d'aliments ; 9 rapide, imprécis sur les quantités ; 10 Observation directe ; 11 grille d'observation d'un repas ou d'un goûter ; 12 comportement réel, effet de l'observateur ; 13 Pesée des restes ; 14 différence entre servi et consommé ; 15 objective, ne dit pas qui mange quoi.

2. a) Pesée des restes : elle mesure objectivement ce qui reste, par composante, sur un grand nombre de repas. b) Observation directe avec une grille : seule méthode qui décrit l'ambiance, la durée et les interactions réelles. c) Questionnaire de fréquence : rapide, adapté à un grand groupe et à une question sur une habitude. d) Rappel des 24 heures : entretien précis sur la veille, adapté à une personne âgée qui ne pourrait pas tenir un carnet (en vérifiant les quantités avec des photos de portions).

Corrigé – Exercice 4.44

1. Légendes : 1 Aliments pas ou peu transformés ; 2 fruits, légumes, œufs, lait, viande fraîche, légumes secs, farine ; 3 Ingrédients culinaires transformés ; 4 huile, beurre, sucre, sel ; 5 Aliments transformés ; 6 pain de boulangerie, fromages, conserves de légumes, fruits au sirop ; 7 Produits ultra-transformés ; 8 sodas, biscuits, nuggets, plats préparés avec additifs.

2. Groupe 1 : a) lentilles sèches, f) lait demi-écrémé. Groupe 2 : b) huile de colza, i) sucre. Groupe 3 : d) haricots verts en conserve, g) fromage. Groupe 4 : c) pain de mie avec émulsifiants et conservateur, e) nuggets avec arômes et amidon modifié, h) soda aux édulcorants, j) yaourt aux fruits avec arôme, épaississant et colorant.

3. Le Nutri-Score est calculé à partir de la composition nutritionnelle (énergie, sucres, graisses saturées, sel, fibres, protéines, fruits et légumes) ; il ne tient pas compte des procédés ni des additifs. Un produit reformulé, peu sucré et peu gras, mais contenant des édulcorants, des arômes et des émulsifiants, peut obtenir un bon score tout en étant ultra-transformé.

4. « Des études associent une consommation élevée de produits ultra-transformés à des risques pour la santé, même si les causes exactes sont encore discutées. Sans les supprimer, on peut en réduire la place en préférant, quand c'est possible, les produits simples et peu chers : légumes secs, légumes surgelés nature, pain, yaourt nature avec un fruit. »

Corrigé – Exercice 4.45

1. Légendes : 1 Santé ; 2 nutritionnellement adéquate, sûre et saine ; 3 Environnement ; 4 protège la biodiversité et les écosystèmes, économise les ressources ; 5 Économie ; 6 accessible, abordable, rémunère équitablement ; 7 Culture et société ; 8 acceptable culturellement, respecte les traditions.

2. Plan actuel : 6 × 2,8 + 6 × 0,6 + 4 × 0,3 + 4 × 0,06 = 16,8 + 3,6 + 1,2 + 0,24 = 21,84 kg éq. CO2 par élève. Plan modifié : 2 × 2,8 + 6 × 0,6 + 4 × 0,3 + 8 × 0,06 = 5,6 + 3,6 + 1,2 + 0,48 = 10,88 kg. Réduction : 21,84 − 10,88 = 10,96 kg, soit 10,96 / 21,84 × 100 = 50,2 %.

3. 10,96 × 400 = 4 384 kg, soit près de 4,4 tonnes d'équivalent CO2 en quatre semaines.

4. Plan actuel : 6 × 0,89 + 6 × 0,75 + 4 × 0,56 + 4 × 0,16 = 5,34 + 4,50 + 2,24 + 0,64 = 12,72 € par élève. Plan modifié : 2 × 0,89 + 6 × 0,75 + 4 × 0,56 + 8 × 0,16 = 1,78 + 4,50 + 2,24 + 1,28 = 9,80 €. Économie : 12,72 − 9,80 = 2,92 € par élève, soit 2,92 × 400 = 1 168,00 € en quatre semaines.

5. Oui : les plats aux œufs (4) et aux légumineuses (8) font 12 plats sans viande ni poisson en 4 semaines, soit 3 par semaine en moyenne, au-delà du minimum d'un par semaine, à condition qu'ils soient répartis sur les quatre semaines.

6. Acheter des produits durables et de qualité (volaille sous label, légumes bio de producteurs locaux) pour se rapprocher des objectifs de la loi EGalim : dimensions économique (rémunération équitable) et

environnementale ; financer des animations de découverte des légumineuses avec les élèves : dimension culturelle et sociale.

7. Des recettes savoureuses, connues ou inspirées de cuisines appréciées (chili, dahl, falafels, hachis parmentier aux lentilles), testées avec les élèves ; une présentation positive (« plat du chef ») sans culpabiliser les mangeurs de viande ; une formation des cuisiniers aux légumineuses.

Corrigé – Exercice 4.46

1. Effectif : 5 + 9 + 6 + 3 + 1 = 24. Somme des notes : 5 × 5 + 4 × 9 + 3 × 6 + 2 × 3 + 1 × 1 = 25 + 36 + 18 + 6 + 1 = 86. Moyenne : 86 / 24 = 3,58.

2. Acceptation : (5 + 9) / 24 × 100 = 58,3 %. Rejet : (3 + 1) / 24 × 100 = 16,7 %.

3. Les notes classées : une note 1 (rang 1), trois notes 2 (rangs 2 à 4), six notes 3 (rangs 5 à 10), neuf notes 4 (rangs 11 à 19), cinq notes 5 (rangs 20 à 24). La médiane est la moyenne des 12e et 13e valeurs : (4 + 4) / 2 = 4.

4. Hasard : 30 / 3 = 10 bonnes réponses attendues. Obtenu : 13 / 30 × 100 = 43,3 % (contre 33,3 % au hasard).

5. Pour 30 participants, il faut au moins 15 bonnes réponses pour conclure à une différence perçue au risque de 5 %. Avec 13, on ne peut pas conclure que les participants perçoivent la réduction de 25 % du sucre : elle passe inaperçue pour la plupart.

6. Les deux recettes peuvent entrer dans le livret : le velouté est bien accepté (58,3 % d'acceptation, médiane 4) et la compote moins sucrée n'est pas distinguée de la compote habituelle. On interroge les participants qui ont noté 1 ou 2 sur ce qui leur a déplu (texture, goût, couleur) pour ajuster la recette (ajout de carottes, d'épices, de croûtons) sans dénaturer le plat.

7. Hygiène : respect de la chaîne du froid et des dates, coupelles et cuillères à usage unique ou lavées, lavage des mains. Allergies : affichage de la liste des ingrédients et des allergènes de chaque préparation, et question posée à chaque participant avant la dégustation.

Corrigé – Exercice 4.47

1. Légumes : 320 × 150 g = 48 000 g = 48,0 kg. Parts des restes : crudités 9,2 / 25,6 × 100 = 35,9 % ; plat protidique 4,8 / 32,0 = 15,0 % ; légumes 21,6 / 48,0 = 45,0 % ; féculents 6,2 / 48,0 = 12,9 % ; fruit 13,4 / 38,4 = 34,9 % ; pain 3,1 / 9,6 = 32,3 %. Classement : légumes (45,0 %) > crudités (35,9 %) > fruit (34,9 %) > pain (32,3 %) > plat protidique (15,0 %) > féculents (12,9 %).

2. Servi : 25,6 + 32,0 + 48,0 + 48,0 + 38,4 + 9,6 = 201,6 kg. Restes : 9,2 + 4,8 + 21,6 + 6,2 + 13,4 + 3,1 = 58,3 kg. Part : 58,3 / 201,6 × 100 = 28,9 %. Par repas : 58 300 / 320 = 182 g.

3. Néophobie et sélectivité encore présentes chez certains adolescents pour les légumes cuits ; influence des pairs (on ne prend pas ou on ne mange pas les légumes devant les copains) ; temps de repas trop court, avec priorité au plat et aux féculents qui rassasient vite ; fruits entiers difficiles à manger (pommes dures, oranges à éplucher) ; présentation peu attractive, portions identiques pour tous quelle que soit la faim ; pain pris par habitude en quantité trop grande.

4. Servir les légumes en portion modulable (« petite ou grande faim ») avec possibilité de se resservir ; améliorer le goût et la présentation des légumes avec les élèves (commission menus, recettes testées, assaisonnement, légumes rôtis) ; proposer les fruits coupés ou en quartiers ; mettre le pain en libre-service en fin de chaîne, en petits morceaux ; allonger le temps de repas et réduire l'attente ; afficher chaque semaine le poids des restes avec un objectif commun. On ne réduit pas les légumes : on augmente leur consommation.

5. La pesée globale ne dit pas qui mange quoi : on ne sait pas si quelques élèves laissent tout ou si chacun laisse un peu. On peut la compléter par l'observation directe d'un échantillon de repas avec une grille, ou par un court questionnaire aux élèves sur leurs raisons.

Corrigé – Exercice 4.48

1. Document 1 (20 repas) : éducateur assis et mangeant avec les jeunes 7 / 20 × 100 = 35,0 % ; conflit 9 / 20 = 45,0 % ; repas de moins de 15 minutes 12 / 20 = 60,0 % ; téléphones à table 11 / 20 = 55,0 %. Document 2 : taux de réponse 38 / 42 × 100 = 90,5 % ; petit-déjeuner sauté au moins 3 jours 17 / 38 = 44,7 % ; nourriture gardée dans la chambre 14 / 38 = 36,8 % ; mange quand il est triste ou en colère 20 / 38 = 52,6 % ; n'aime pas la plupart des plats 23 / 38 = 60,5 % ; aimerait cuisiner 29 / 38 = 76,3 %. Document 3 : restes 88,2 / 294 × 100 = 30,0 % ; restes par repas 88 200 / 588 = 150 g ; portion moyenne servie 294 000 / 588 = 500 g.

2. Rôles de l'acte alimentaire : pour des jeunes séparés de leur famille, le repas a un rôle psychologique et affectif majeur (sécurité, attention de l'adulte) et un rôle social (vivre ensemble) ; or l'éducateur ne mange avec les jeunes qu'à 35,0 % des repas et « surveille debout », les repas sont courts (60,0 % de moins de 15 minutes) et les téléphones présents (55,0 %) : le repas perd sa fonction de lien. Alimentation émotionnelle et stratégies liées au manque : 52,6 % mangent quand ils sont tristes ou en colère ; 36,8 % gardent de la nourriture dans leur chambre ; la jeune de 14 ans l'explique par le manque vécu chez sa mère : c'est une stratégie de sécurité, pas un caprice. Partage des responsabilités : priver de dessert celui qui ne mange pas (« il n'aura pas de dessert ») et les conflits (45,0 % des repas) font du repas un enjeu de pouvoir et perturbent la régulation. Néophobie et identité culturelle : « je ne connais pas ces légumes, c'est pas comme chez moi » ; 60,5 % n'aiment pas la plupart des plats ; le « riz au poisson » du week-end, synonyme de fête, rappelle l'importance des plats de la famille, liés à l'identité. Les restes (30,0 %, 150 g par repas) traduisent ce décalage.

3. Tableau des déterminants : biologiques et sensoriels, âge (6-17 ans : néophobie chez les plus jeunes, besoins de croissance des adolescents), absence de faim le matin (44,7 % sautent le petit-déjeuner) ; psychologiques, émotions et histoire de manque (52,6 % mangent sous le coup d'une émotion, stockage de nourriture) ; cognitifs, plats inconnus (« je ne connais pas ces légumes »), peu de compétences culinaires mais une envie d'apprendre (76,3 % aimeraient cuisiner) ; sociaux et culturels, cultures familiales (riz au poisson), règles de l'équipe (dessert comme sanction), place de l'éducateur à table ; économiques, budget de l'établissement et de la cuisine, coût du gaspillage (88,2 kg par semaine) ; environnementaux, organisation des repas (durée courte, téléphones, éducateur debout), offre de la cuisine centrale peu adaptée aux goûts.

4. Objectif général : faire des repas de la MECS un moment de plaisir, de sécurité et de lien, qui contribue à une alimentation adaptée aux besoins des jeunes. Objectifs spécifiques : d'ici juin 2027, faire passer de 35,0 % à au moins 80 % la part des repas où un éducateur mange à table avec les jeunes ; d'ici juin 2027, réduire la part des restes de 30,0 % à moins de 20 %. Objectifs opérationnels : former avant décembre 2026 les éducateurs des cinq groupes de vie à une séance de deux heures sur le repas éducatif (feuille de présence) ; organiser, de janvier à juin 2027, un atelier cuisine par mois et par groupe de vie (30 ateliers, cahier de suivi).

5. Action 1, « l'éducateur à table » : obtenir de la direction que les éducateurs prennent le même repas que les jeunes, assis, et définir avec l'équipe des règles communes (pas de dessert comme sanction ni comme récompense, pas de téléphone à table, durée minimale de 25 minutes) ; notions : rôle affectif et social du repas, partage des responsabilités. Action 2, « ateliers cuisine du monde » mensuels dans chaque groupe de vie, où les jeunes cuisinent avec un éducateur et la cuisinière, en partant de plats de leurs familles (riz au poisson, mafé, couscous) adaptés avec des légumes de saison ; notions : identité culturelle, syncrétisme, exposition répétée, efficacité personnelle ; pour les petits, recettes simples et sensorielles. Action 3, « petit-déjeuner et goûter assurés » : un petit-déjeuner servi sur un créneau plus long, avec des choix (pain, céréales simples, produits laitiers, fruits) et une collation emportée pour ceux qui n'ont pas faim le matin ; et une « boîte du soir » dans chaque groupe de vie (fruits, pain, compotes), accessible la nuit, pour répondre au besoin de sécurité des jeunes qui stockent, sans le leur reprocher ; notions : rythmes, stratégies liées au manque. Action 4, « commission menus » trimestrielle avec deux jeunes par groupe, la cuisinière et le diététicien, pour choisir des plats, tester des recettes et suivre les restes ; notions : participation, réduction du gaspillage, acceptation des plats.

6. Budget : formation des éducateurs (intervenant et supports) 250,00 € ; ateliers cuisine, denrées : 30

ateliers × 30,00 € = 900,00 € ; petit matériel de cuisine pour les groupes de vie (tabliers, ustensiles adaptés aux enfants) 260,00 € ; boîtes du soir et contenants : 5 × 40,00 € = 200,00 € ; impression d'un livret de recettes des familles 90,00 € ; sous-total 250,00 + 900,00 + 260,00 + 200,00 + 90,00 = 1 700,00 € ; imprévus : 1 800 − 1 700 = 100,00 € (5,6 %) ; total 1 800,00 €. Les fruits et le pain des boîtes du soir sont pris sur le budget habituel de la cuisine, compensé par la baisse du gaspillage.

7. Processus : nombre d'éducateurs formés ; nombre d'ateliers réalisés et de jeunes participants par atelier ; nombre de commissions menus tenues et de recettes adoptées ; respect du budget. Résultats : nouvelle observation de 20 repas avec la même grille en juin 2027 (part des repas avec un éducateur à table, conflits, durée, téléphones) ; nouvelle pesée des restes sur une semaine (objectif : moins de 20 %) ; même questionnaire anonyme des jeunes (petit-déjeuner, alimentation émotionnelle, appréciation des plats) ; entretien de groupe avec les éducateurs. Calendrier : diagnostic en octobre 2026, formation en novembre-décembre, actions de janvier à juin 2027, évaluation en juin 2027 et bilan à la direction en septembre 2027.

8. Respect de la confidentialité de l'histoire des jeunes (on ne cite jamais la situation familiale d'un jeune devant le groupe) ; questionnaire anonyme, résultats présentés seulement de façon collective ; aucun jeune n'est forcé à participer ni à goûter ; on ne prive jamais de nourriture et on ne retire pas les réserves de la chambre de façon punitive, on comprend leur sens ; respect des pratiques religieuses et culturelles des familles ; aucun commentaire sur le poids ou le corps. Avec l'équipe : posture de soutien et non de jugement (les éducateurs agissent avec de fortes contraintes), co-construction des règles du repas, lien avec le psychologue et le médecin de l'établissement pour les jeunes dont le rapport à la nourriture inquiète (signes de TCA, crises, stockage massif).

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Citer et illustrer les six rôles de l'acte alimentaire ; définir le comportement alimentaire ; distinguer besoin, envie, oralité, pulsion ; calculer la part de l'alimentation dans un budget	4.1 à 4.6			
2	Situer faim, rassasiement et satiété ; expliquer les systèmes de régulation ; utiliser le rassasiement sensoriel spécifique, la taille des portions et la densité énergétique	4.7 à 4.12			
3	Expliquer la restriction cognitive ; nommer les dérégulations ; situer les TCA ; prévenir, repérer et orienter sans stigmatiser	4.13 à 4.18			
4	Classer les déterminants ; reconnaître un environnement obésogène ; décrire les stratégies des ménages précaires ; calculer le coût de 100 kcal	4.19 à 4.24			
5	Décrire l'évolution du modèle français et le syncrétisme ; reconnaître les pratiques actuelles et leurs points de vigilance ; adapter une recette aux pratiques religieuses	4.25 à 4.30			
6	Distinguer repas, collation et grignotage ; calculer une répartition de l'énergie ; argumenter sur la collation et le petit-déjeuner ; relier comportements et âges de la vie	4.31 à 4.36			
7	Décrire le développement du comportement alimentaire ; utiliser l'exposition répétée et le partage des responsabilités ; conseiller sur la diversification	4.37 à 4.42			
8	Choisir un outil de mesure ; classer selon NOVA ; calculer une empreinte carbone ; exploiter une dégustation et une pesée des restes ; traiter un cas complet	4.43 à 4.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5

04

CHAPITRE

04

Pratiques et comportements alimentaires

Rôles de l'acte alimentaire

Régulation

Pratiques actuelles

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 4 229
Mode d'emploi du cahier d'annales 229
Ce que le jury attend sur ce chapitre 229
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 230
S1 – « Ici, on mange quand on peut » : rythmes, grignotage et prise de poids en maison d'arrêt 230
S2 – « Fait maison en 30 minutes » : un atelier pour des parents qui élèvent seuls leurs enfants 233
S3 – « Loin de tout, mais pas sans ressources » : pratiques alimentaires dans une communauté de communes rurale 237
Partie II – Les corrigés détaillés 240
Corrigé S1 – « Ici, on mange quand on peut » : rythmes, grignotage et prise de poids en maison d'arrêt 240
Corrigé S2 – « Fait maison en 30 minutes » : un atelier pour des parents qui élèvent seuls leurs enfants 247
Corrigé S3 – « Loin de tout, mais pas sans ressources » : pratiques alimentaires dans une communauté de communes rurale 252
Grille d'auto-évaluation 258

Cahier d'annales E5 – chapitre 4

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes et les données des enquêtes sont fictives : elles sont construites pour l'entraînement et ne doivent pas être citées comme des données réelles. Les données nationales et les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Ici, on mange quand on peut » : rythmes, grignotage et prise de poids en maison d'arrêt	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Fait maison en 30 minutes » : un atelier pour des parents qui élèvent seuls leurs enfants	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Loin de tout, mais pas sans ressources » : pratiques alimentaires dans une communauté de communes rurale	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 4 porte sur le mangeur et ses pratiques : rôles de l'acte alimentaire, régulation et dérégulation (faim, rassasiement, alimentation émotionnelle, restriction cognitive), déterminants, rythmes et structure des prises, évolution des pratiques (mangeur pluriel, syncrétisme, ultra-transformation, alimentation durable), pratiques selon les âges, les cultures et les situations de précarité, observation et mesure des comportements. Le jury vérifie que le candidat sait **décrire** des pratiques avec des outils adaptés (questionnaire, carnet, rappel des 24 heures, score de diversité), **comprendre** leur logique sans les juger (contraintes, sens, plaisir, identité), puis **proposer** des actions réalistes qui partent des pratiques existantes, dans le respect des personnes et de leurs ressources.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; surligner le public, ses contraintes (horaires, budget, équipement, lieu de vie), ce que disent les personnes et le verbe de chaque consigne. Pendant : pour chaque donnée, écrire le calcul, le résultat et une phrase d'interprétation qui nomme une notion du chapitre (rythme, prise hors repas, alimentation émotionnelle, déterminant, ultra-transformation) et le levier qui en découle. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Ici, on mange quand on peut » : rythmes, grignotage et prise de poids en maison d'arrêt

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II).

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année à l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP) de la maison d'arrêt de Montrevel (structure fictive). L'USMP est une unité du centre hospitalier voisin : médecins, infirmières, psychologues, un dentiste et une diététicienne présente une demi-journée par semaine. La maison d'arrêt accueille 420 hommes majeurs, prévenus ou condamnés à de courtes peines, pour 300 places. Le médecin responsable vous confie une demande : « Beaucoup de détenus prennent du poids dans les premiers mois. Ils mangent tard, seuls en cellule, grignotent le soir devant la télévision et achètent des sodas et des biscuits à la cantine. Plusieurs nous disent qu'ils mangent "pour tuer le temps". Les conseils individuels en consultation ne suffisent pas. » Vous devez comprendre les pratiques alimentaires de ce public, concevoir un projet, en réaliser une partie pendant votre stage et en rendre compte dans votre dossier E5.

Document 1 – La structure, le public et les moyens

- Repas fournis par l'établissement et distribués en cellule par des détenus « auxiliaires » : déjeuner à 11 h 30, dîner à 17 h 30 ; le petit-déjeuner du lendemain (un kit : café soluble, sucre, lait en poudre, biscottes, confiture) est remis avec le dîner.
- « Cantine » : chaque semaine, les détenus peuvent acheter des produits sur leur compte (boissons, biscuits, chips, conserves, pâtes, œufs, fruits, produits d'hygiène). Les cellules disposent d'un réfrigérateur loué et d'une plaque chauffante ; beaucoup de détenus cuisinent eux-mêmes une partie de leurs repas.
- Activités : promenade deux fois une heure par jour ; salle de sport (inscription, liste d'attente) ; unité locale d'enseignement ; travail en atelier pour 60 détenus.
- Partenaires possibles : direction de l'établissement et surveillants, service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), prestataire de restauration, enseignants, moniteur de sport, association socioculturelle, aumônerie, associations d'aide alimentaire à la sortie.
- Budget : 1 500 € accordés par l'agence régionale de santé au titre de la promotion de la santé en milieu pénitentiaire, pour un an, matériel compris.

Document 2 – Questionnaire auprès des détenus (données fictives, 126 répondants volontaires)

Le questionnaire a été proposé à tous les détenus par l'USMP et rempli de façon anonyme, avec l'aide d'une infirmière pour la lecture si besoin.

Question	Nombre de « oui » (n = 126)
Ne consomme pas le kit petit-déjeuner, au moins 5 matins sur 7	54
Mange toujours seul en cellule	98

Question	Nombre de « oui » (n = 126)
Grignote le soir après 20 h, au moins 5 soirs sur 7	71
Achète des sodas ou des boissons sucrées à la cantine chaque semaine	77
Cuisine en cellule au moins une fois par semaine	62
Déclare manger souvent « par ennui » ou « pour se calmer »	69
Pratique une activité physique au moins 3 fois par semaine	40

Document 3 – Évolution du poids des entrants (données fictives, dossiers de l'USMP anonymisés)

Pour les 80 détenus entrés au cours de l'année précédente et toujours présents six mois plus tard, l'USMP a relevé le poids à l'entrée et à six mois.

- Poids moyen : 74,6 kg à l'entrée ; 78,9 kg à six mois.
- Répartition de la variation de poids : perte de 5 % ou plus : 6 ; variation inférieure à 5 % : 30 ; gain de 5 % à moins de 10 % : 26 ; gain de 10 % ou plus : 18.
- Croisement : parmi les 48 détenus qui achètent des boissons sucrées chaque semaine, 32 ont pris au moins 5 % de leur poids ; parmi les 32 qui n'en achètent pas, 12 ont pris au moins 5 % de leur poids.

Document 4 – Carnets de consommation (données fictives) et paroles de détenus

Douze détenus volontaires ont noté pendant trois jours toutes leurs prises alimentaires. Nombre moyen de prises par jour et, entre parenthèses, nombre de prises en dehors des trois prises prévues par l'établissement (kit petit-déjeuner, déjeuner, dîner) : 5 (2) ; 7 (4) ; 6 (3) ; 8 (5) ; 4 (1) ; 6 (3) ; 9 (6) ; 5 (2) ; 7 (4) ; 6 (3) ; 8 (5) ; 5 (2).

« Le dîner à 17 h 30, à 22 h j'ai faim, alors je mange des gâteaux. » (Karim, 34 ans)

« Ici, il n'y a rien à faire. Manger, c'est le seul moment où il se passe quelque chose. » (Julien, 27 ans)

« Les biscottes du matin, je les donne. Je dors jusqu'à midi. » (Sofiane, 22 ans)

« Quand je cuisine avec mon codétenu, on parle, on fait comme à la maison. » (Mamadou, 41 ans)

« Les fruits à la cantine, ils sont chers et ils s'abîment dans le frigo. » (Patrick, 52 ans)

« Avant, je bougeais toute la journée sur les chantiers. Ici, je fais vingt pas. » (David, 38 ans)

Document 5 – Trois situations rencontrées pendant le stage

Un surveillant vous demande la liste des détenus « en obésité » pour « les inscrire en priorité au sport ». Le prestataire de restauration souhaite utiliser les résultats de votre questionnaire dans une plaquette commerciale destinée à d'autres établissements. Un journaliste de la presse locale propose de faire un reportage photo sur votre atelier « pour montrer qu'on s'occupe des détenus ».

Document 6 – Cadre et repères (données réelles)

- Depuis la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, la prise en charge sanitaire des personnes détenues relève du service public hospitalier ; les USMP sont des unités des établissements de santé.
- Les règles pénitentiaires européennes (Conseil de l'Europe, 2006, révisées en 2020) prévoient que les détenus bénéficient d'un régime alimentaire qui tient compte de leur âge, de leur état de santé, de leur religion, de leur culture et de la nature de leur travail (règle 22).
- La feuille de route nationale « Santé des personnes placées sous main de justice 2024-2028 » (ministères chargés de la santé et de la justice) prévoit 34 actions, dont le développement de la prévention et de la promotion de la santé en détention ; elle fait suite à celle de 2019-2022.
- L'OMS (2015) recommande de limiter les sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique, et

idéalement à moins de 5 %.

- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) conseille de limiter les boissons sucrées et de ne pas dépasser un verre par jour.

Travail à faire

Partie A – Le projet d'intervention (dossier écrit de 10 pages au plus) – C3.1 (9 points)

1. Calculez les indicateurs du document 2 et le taux de participation ; calculez la variation moyenne du poids (en kg et en %) et la répartition des entrants selon la variation du poids (document 3). Posez le diagnostic. (2 pts)

2. Calculez, à partir des carnets du document 4, le nombre moyen de prises par jour, le nombre moyen de prises hors repas et leur part. Calculez la durée du jeûne entre le dîner et le repas suivant pour un détenu qui ne consomme pas le kit petit-déjeuner. Analysez la structure des prises avec les notions du chapitre (rythmes, déstructuration, prise hors repas). (2 pts)

3. Analysez les pratiques alimentaires des détenus avec les notions du chapitre : rôles de l'acte alimentaire, régulation et dérégulation (alimentation émotionnelle, ennui), déterminants individuels et environnementaux, dimension sociale du repas. Formulez le problème central, ses causes et ses conséquences. (2 pts)

4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et des objectifs opérationnels, chacun avec un indicateur, une valeur cible et une échéance. (1,5 pt)

5. Présentez le plan d'action sur un an, en associant les détenus, et un budget qui respecte les 1 500 €. Justifiez chaque action par une notion du chapitre. (1,5 pt)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée – C3.3 (3 points)

6. Calculez le risque relatif de prise de poids d'au moins 5 % selon l'achat de boissons sucrées et son intervalle de confiance à 95 %, avec la formule : $IC = \exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d)})$, où a et c sont les nombres de détenus qui ont pris du poids dans chaque groupe, et a + b et c + d les effectifs des groupes. Interprétez. Peut-on conclure que les boissons sucrées sont la cause de la prise de poids ? (1,5 pt)

7. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion de détenus qui grignotent le soir et la taille d'échantillon nécessaire pour une précision de ± 5 points, avec correction pour une population de 420. Présentez trois limites des carnets de consommation dans ce contexte. (1,5 pt)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

8. Organisez une veille sur la santé et l'alimentation en milieu pénitentiaire et sur les interventions qui réduisent le grignotage et l'alimentation émotionnelle : sources fiables, outils, fréquence, diffusion. (2 pts)

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique – C3.5 et C3.6 (3 points)

9. Analysez les trois situations du document 5 (secret médical, données de santé, usage commercial des résultats, droit à l'image) et rédigez votre réponse à chacun des demandeurs. (1,5 pt)

10. Proposez des supports de communication adaptés à ce public (niveau de lecture variable, langues, absence d'internet) ; rédigez la trame minutée de votre exposé de 10 minutes et listez 15 questions probables du jury. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Fait maison en 30 minutes » : un atelier pour des parents qui élèvent seuls leurs enfants

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des sujets U62 et E5.B (bon de commande, fiche technique, organisation dans le temps, hygiène) et du BTS blanc CNED E5B (adaptation d'une recette et calcul nutritionnel).

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'association « Solo mais pas seul » de Vernières (structure fictive) accompagne des parents qui élèvent seuls leurs enfants. Lors d'un groupe de parole, les parents ont expliqué qu'ils travaillent souvent en horaires décalés (caisse, aide à domicile, nettoyage), qu'ils rentrent fatigués et qu'ils achètent des nuggets, de la purée en flocons et des compotes en gourde « parce que c'est rapide et que les enfants aiment ». Plusieurs se sentent coupables : « Je sais que ce n'est pas bien, mais je n'ai ni le temps ni l'argent pour cuisiner. » L'association vous demande de concevoir et d'animer un atelier « Fait maison en 30 minutes », le samedi matin, pendant que les enfants sont accueillis par des bénévoles dans la salle voisine. Les enfants rejoignent leurs parents pour le repas.

Document 1 – Le public et les contraintes

- 8 parents de 26 à 47 ans (7 mères, 1 père), chacun avec un à trois enfants de 3 à 12 ans.
- Le fils de Madame T. (6 ans) est allergique à l'œuf ; Madame B. ne consomme que de la viande halal ; Monsieur K. a un fils de 3 ans « qui ne mange que mixé ou en petits morceaux » ; deux mères disent « ne rien savoir faire » en cuisine.
- Cuisine de l'association : 4 plaques à induction, 2 fours, 1 four à micro-ondes, 1 mixeur plongeant, 1 réfrigérateur, 4 postes de travail pour 2 personnes.
- Budget denrées : au plus 2,50 € par portion « adulte » ; on prévoit 10 portions (8 parents et 2 professionnels). Les portions des enfants pour le repas sont fournies par l'association et ne sont pas comptées dans le budget de l'atelier.
- Durée de l'atelier avec le public : 2 h 30, de 9 h 30 à 12 h 00, repas compris. Le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 2 – Menu imposé

Plat : nuggets de poulet maison panés aux pétales de maïs, cuits au four ; purée de carottes et de pommes de terre.

Dessert : compote minute pomme-banane (four à micro-ondes).

Le candidat réalise le plat et le dessert. Il présente aussi les adaptations pour le fils de Madame T. (allergie à l'œuf), pour Madame B. (halal) et pour le fils de Monsieur K. (3 ans), ainsi qu'une version « cuisiner une fois pour deux soirs » avec congélation.

Document 3 – Grammages nets par portion adulte, pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Grammage net par portion	Perte au parage ou à l'épluchage	Prix
Filet de poulet sans peau (existe en halal au même prix)	100 g	sans perte	11,90 € le kg

Denrée	Grammage net par portion	Perte au parage ou à l'épluchage	Prix
Pétales de maïs nature, non sucrés	20 g	sans perte	4,20 € le kg
Œuf entier	10 g (2 œufs de 50 g pour 10 portions)	sans perte	0,30 € l'œuf
Farine de blé T55	8 g	sans perte	1,10 € le kg
Huile de colza	5 g	sans perte	3,20 € le kg
Pommes de terre	120 g	20 %	1,20 € le kg
Carottes	100 g	15 %	1,50 € le kg
Lait demi-écrémé UHT	40 g	sans perte	1,05 € le kg
Beurre doux	5 g	sans perte	9,50 € le kg
Pommes	80 g	20 %	2,40 € le kg
Bananes	40 g	35 %	2,00 € le kg
Paprika doux, ail en poudre, sel, poivre, cannelle, papier sulfurisé	–	–	forfait 0,60 € pour l'atelier

Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte).

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Poulet, filet sans peau cru	110	23,4	0	traces	1,5	0	0,11
Pétales de maïs nature, non enrichis en vitamines et minéraux	372	6,88	82,4	4,12	0,7	4,6	1,82
Oeuf cru	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31
Farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains)	350	9,03	73,7	1,5	1	3,2	< 0,13
Huile de colza	900	0	0	0	100	0	< 0,0028
Pomme de terre, sans peau, crue	80	2,02	16,2	0,78	0,09	2,2	< 0,0011
Carotte, crue	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12
Lait demi-écrémé, UHT	47,7	3,48	5	4,96	1,56	0	0,088
Beurre à 80% MG minimum, doux	753	0,64	0,71	0,71	83	0	0,035
Pomme, chair sans peau, crue (aliment moyen)	51,3	0,26	11,9	11,4	0,24	2,39	0,0064
Banane, chair sans peau, crue	87,6	1,06	19,7	15,6	< 0,5	2,7	< 0,013

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (fichier du 3 novembre 2025, mis en ligne le 19 novembre 2025).

Document 5 – Le repas « habituel » des familles (composition : Ciqual 2025 ; prix construits pour le sujet)

Produit (libellé Ciqual 2025)	Portion adulte	Énergie (kcal / 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Prix de la portion
Nuggets ou croquette panée de poulet, préemballé	130 g	250	15,6	19,4	1,3	11,6	2,4	1,37	1,29 €
Purée de pomme de terre, à base de flocons, reconstituée avec lait entier et matière grasse	220 g	107	1,92	12,6	1,68	5,18	1,47	0,56	0,45 €
Compote de pomme, préemballée	100 g	107	0,25	25,8	22,6	0,23	1,54	0,031	0,30 €

Document 6 – Repères utiles (données réelles)

- La classification NOVA (Monteiro et collaborateurs, 2009, version actualisée en 2016) range les aliments en quatre groupes selon leur degré de transformation : 1) aliments pas ou peu transformés ; 2) ingrédients culinaires transformés (huile, beurre, sucre, sel) ; 3) aliments transformés ; 4) produits ultra-transformés, fabriqués industriellement avec des ingrédients et des additifs peu ou pas utilisés en cuisine domestique.
- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) conseille de privilégier le fait maison et de limiter les produits ultra-transformés, ainsi que les produits gras, sucrés, salés.
- Apport en sel : moins de 5 g par jour pour un adulte (OMS, 2012) ; l'OMS recommande aussi de limiter les sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique (2015).
- Le règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) impose d'informer les consommateurs sur la présence de 14 allergènes, y compris dans les denrées non préemballées servies en restauration.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (11 points)

1. Identifiez les besoins de ce public (contraintes, représentations, attentes, culpabilité) et formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier. (2 pts)
2. Établissez le bon de commande pour 10 portions (quantités nettes, quantités brutes, unités de commande, coût) ; calculez le coût par portion, vérifiez le respect du budget et comparez-le au coût du repas habituel (document 5). (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique des nuggets maison (ingrédients, matériel, étapes, points critiques) et une fiche « famille » simplifiée ; présentez les adaptations demandées et la version « cuisiner une fois pour deux soirs ». (3 pts)
4. Calculez l'apport d'une portion du repas maison et du repas habituel (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel) et la répartition de l'énergie ; comparez. Classez chaque ingrédient et chaque produit selon NOVA et discutez la place des pétales de maïs. (2 pts)
5. Expliquez, avec les notions du chapitre (déterminants, temps et charge mentale, rôle nourricier, mangeur pluriel, culpabilité et injonctions), pourquoi ces parents achètent des produits ultra-transformés et comment l'atelier peut les aider sans les culpabiliser. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et participants), en organisant le travail en binômes et l'arrivée des enfants pour le repas. (2 pts)

7. Présentez les méthodes d'animation, les outils (fiche recette illustrée, chronomètre « 30 minutes », comparaison des étiquettes) et une grille de dégustation pour les parents et pour les enfants. (1,5 pt)

8. Présentez les règles d'hygiène (5 M, volaille crue, œuf, cuisson à cœur, congélation et décongélation), la gestion des allergènes et trois éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

9. Réalisez les nuggets, la purée et la compote ; dressez une assiette adulte et une assiette pour un enfant de 3 ans. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier (satisfaction, acquis, temps réel de préparation, intention de refaire). (1 pt)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Loin de tout, mais pas sans ressources » : pratiques alimentaires dans une communauté de communes rurale

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet mixte – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) sur une même situation

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : 30 min d'oral préparé (temps 1) et 3 h (temps 2) · Barème : 20 points par temps.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique au centre social intercommunal de la communauté de communes du Haut-Vallon (structure fictive). Le territoire compte 9 800 habitants répartis dans 21 communes, dont 14 n'ont plus aucun commerce alimentaire. Le seul supermarché est situé dans le bourg-centre ; une épicerie itinérante passe une fois par semaine dans les villages. La communauté de communes prépare un projet alimentaire territorial. La directrice du centre social vous confie une mission : « Les élus pensent que les habitants mangent mal parce qu'ils sont loin des magasins. Mais beaucoup ont un potager, font des conserves, achètent à la ferme. Nous voulons comprendre ce qu'ils mangent vraiment, et construire avec eux des actions qui partent de leurs ressources. »

Document 1 – Données réelles sur l'alimentation et les territoires

- Les projets alimentaires territoriaux (PAT) ont été créés par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ; ils sont élaborés de manière concertée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire.
- La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (dite EGalim) impose à la restauration collective publique au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l'agriculture biologique.
- Le score de diversité alimentaire des ménages (HDDS, FANTA, 2006 ; guide de la FAO, 2011) compte le nombre de groupes d'aliments consommés par le ménage au cours des 24 heures précédentes, parmi 12 groupes : céréales ; racines et tubercules ; légumes ; fruits ; viandes et abats ; œufs ; poissons et fruits de mer ; légumineuses, noix et graines ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses ; sucre et miel ; condiments, épices et boissons. Le score va de 0 à 12.

Document 2 – Enquête auprès des ménages (données fictives)

150 ménages sur 4 300 ont répondu à un questionnaire distribué par les mairies, l'épicerie itinérante et au marché du bourg.

Question	Nombre de « oui » (n = 150)
Le ménage n'a pas de voiture	21
La personne de référence a 60 ans ou plus	71
Le ménage cultive un potager	87
Le ménage fait des conserves ou des congélations de produits du jardin	64
Achète directement à un producteur au moins une fois par mois	52
Consomme des légumes secs au moins une fois par semaine	39
Consomme des plats préparés industriels au moins 3 fois par semaine	33
Prend le repas du soir en famille ou à plusieurs chaque jour	108

Score de diversité alimentaire (HDDS) calculé à partir d'un rappel des 24 heures auprès de 14 ménages : ménages avec potager : 9 ; 8 ; 10 ; 7 ; 9 ; 8 ; 11 ; 9 ; ménages sans potager : 6 ; 5 ; 7 ; 6 ; 8 ; 5.

Document 3 – Ce que disent les habitants et moyens disponibles

« L'hiver, on mange nos conserves de haricots et de tomates. Les lentilles, je ne sais plus les cuisiner, c'était ma mère. » (Mme L., 71 ans)

« Sans voiture, je dépends de ma voisine pour les courses. Je prends ce qui se garde. » (M. P., 80 ans)

« Les plats tout prêts, c'est pour quand je rentre tard de l'usine. » (Mme C., 38 ans)

« On a trop de courgettes en août, on ne sait plus quoi en faire. » (M. et Mme D.)

Moyens : budget de 1 200 € pour l'année (centre social et communauté de communes) ; salle des fêtes équipée d'une cuisine (4 plaques, 2 fours, 1 réfrigérateur) dans trois villages ; minibus du centre social le jeudi ; un maraîcher et une éleveuse de volailles volontaires ; un club des aînés actif ; l'épicerie itinérante accepte de proposer des produits nouveaux. Le supermarché du bourg propose de financer des affiches « à condition que son logo apparaisse en grand ».

Travail à faire – Temps 1

1. Calculez les indicateurs de l'enquête, le taux de réponse, le score HDDS moyen de chaque groupe et l'écart entre les deux ; présentez les limites de ces données. (4 pts)
2. Analysez les pratiques alimentaires de ce territoire avec les notions du chapitre : déterminants (accès physique et économique, âge, transmission des savoir-faire, temps), autoproduction, saisonnalité, dimension sociale du repas, alimentation durable ; montrez que le territoire a des ressources et pas seulement des manques. (3 pts)
3. Formulez les objectifs (général, spécifiques, opérationnels) et le plan d'action sur 12 mois, construit avec les habitants et les acteurs du futur PAT. (5 pts)
4. Présentez la démarche d'évaluation et un budget qui respecte les 1 200 €. (3 pts)
5. Indiquez les précautions éthiques et juridiques : données personnelles de l'enquête, photos, partenariat avec le supermarché, respect des pratiques et des savoirs des habitants. (3 pts)
6. Expression et sources. (2 pts)

Travail à faire – Temps 2

Document 4 – Atelier imposé et données (prix construits pour le sujet ; composition : table Ciqual 2025, ANSES, 19 novembre 2025)

Atelier « Les légumes secs, comme chez nos grands-mères, en plus rapide » de 2 h 30, de 9 h 30 à 12 h 00, à la salle des fêtes, pour 8 habitants (dont Mme L., M. G., diabétique de type 2 traité par comprimés, et Mme V., 78 ans, qui porte un appareil dentaire et mâche difficilement), suivi du repas pris ensemble. Coût des denrées : au plus 2,00 € par portion ; 10 portions (8 habitants et 2 professionnels).

Menu : lentilles vertes mijotées aux carottes, aux oignons et au chou, œuf poché ; pain de campagne ; pommes au four, fromage blanc au miel.

Grammages nets par portion : lentilles vertes sèches 60 g ; carottes 80 g (15 % de perte) ; oignons 30 g (10 % de perte) ; chou blanc 60 g (20 % de perte) ; huile de colza 5 g ; œuf 1 (50 g sans coquille) ; pain de campagne 40 g ; pomme 130 g (10 % de perte au vidage) ; fromage blanc 2-3 % MG 100 g ; miel 8 g.

Prix : lentilles vertes 3,20 € le kg ; carottes 1,40 € le kg ; oignons 1,60 € le kg ; chou blanc 1,30 € le kg ; huile de colza 3,20 € le kg ; œufs de l'éleveuse 0,32 € pièce ; pain de campagne 3,60 € le kg ; pommes 2,20 € le kg ; fromage blanc 2,60 € le kg ; miel 14,00 € le kg ; thym, laurier, clou de girofle, cannelle, sel, poivre : forfait 0,50 € pour l'atelier.

Aliment (libellé Ciqual 2025), pour 100 g	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)
Lentille verte, sèche	327	25,1	44,5	1,1	1,8	16,4	< 0,13	6,3
Carotte, crue	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12	< 0,25
Oignon, cru	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098	0,00019
Chou blanc, cru	35,2	1,38	4,63	4,2	0,6	3,5	0,033	0,3
Huile de colza	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	0,023
Oeuf cru	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31	1,75
Pain de campagne	253	7,52	50	2,5	1,3	4,3	1,18	1,5
Pomme, chair et peau, crue	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037	0,099
Fromage blanc, nature, 2-3% MG	75,7	7,28	3,86	3,86	3,23	0,019	0,088	< 0,25
Miel	331	0,65	82,1	81,1	0	0	0,01	0,18

On calcule avec les poids nets crus (lentilles sèches). Une teneur notée « < » est comptée 0.

7. Identifiez les besoins des participants et justifiez le menu au regard des pratiques du territoire. (3 pts)

8. Établissez le bon de commande pour 10 portions et le coût par portion ; rédigez la fiche technique des lentilles mijotées ; calculez l'apport d'une portion du plat et du repas complet (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, fer) et la répartition de l'énergie ; présentez les adaptations pour M. G. et Mme V. (5 pts)

9. Présentez l'organisation minutée des 3 heures et la méthode d'animation qui valorise les savoir-faire des participants (transmission entre générations). (4 pts)

10. Présentez l'hygiène (légumes du jardin, œufs, cuisson et conservation des légumineuses cuites), les allergènes et les éco-gestes (saisonnalité, circuits courts, anti-gaspillage). (4 pts)

11. Réalisez le plat et le dessert ; proposez l'évaluation de l'atelier. (4 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Ici, on mange quand on peut » : rythmes, grignotage et prise de poids en maison d'arrêt

que le jury attend

Le jury évalue la capacité à décrire des pratiques alimentaires dans un milieu très contraint, à en comprendre la logique (horaires imposés, ennui, solitude, cantine) et à proposer des actions réalistes, construites avec les personnes et compatibles avec les règles de l'établissement. Il valorise les calculs exacts et interprétés, l'usage juste des notions du chapitre (structure des prises, prise hors repas, alimentation émotionnelle, déterminants, rôle social du repas) et le respect strict du secret médical. Il pénalise les jugements (« ils mangent n'importe quoi »), les actions centrées sur le seul poids et toute proposition qui méconnaît la sécurité pénitentiaire.

Partie A – Le projet d'intervention

Question 1 – Indicateurs et diagnostic (2 pts)

Calcul posé – Indicateurs du questionnaire (n = 126) et du suivi du poids (n = 80)

- Ne consomme pas le kit petit-déjeuner au moins 5 matins sur 7 : 54 / 126 × 100 = **42,9 %**.
- Mange toujours seul en cellule : 98 / 126 × 100 = **77,8 %**.
- Grignote le soir après 20 h au moins 5 soirs sur 7 : 71 / 126 × 100 = **56,3 %**.
- Achète des boissons sucrées chaque semaine : 77 / 126 × 100 = **61,1 %**.
- Cuisine en cellule au moins une fois par semaine : 62 / 126 × 100 = **49,2 %**.
- Mange souvent « par ennui » ou « pour se calmer » : 69 / 126 × 100 = **54,8 %**.
- Activité physique au moins 3 fois par semaine : 40 / 126 × 100 = **31,7 %**.
- Taux de participation : 126 / 420 × 100 = **30,0 %**.
- Variation moyenne du poids : 78,9 − 74,6 = **+ 4,3 kg**, soit 4,3 / 74,6 × 100 = **+ 5,8 %** en six mois.
- Répartition des 80 entrants : perte de 5 % ou plus 6 / 80 = **7,5 %** ; variation inférieure à 5 % 30 / 80 = **37,5 %** ; gain de 5 à moins de 10 % 26 / 80 = **32,5 %** ; gain de 10 % ou plus 18 / 80 = **22,5 %**. Gain d'au moins 5 % : (26 + 18) / 80 = **55,0 %**.

Diagnostic. Plus de la moitié des entrants (55,0 %) prennent au moins 5 % de leur poids en six mois, et près d'un sur quatre (22,5 %) au moins 10 %. Les pratiques déclarées éclairent ce constat : grignotage du soir fréquent (56,3 %), achats hebdomadaires de boissons sucrées (61,1 %), alimentation « par ennui » ou pour se calmer (54,8 %), activité physique rare (31,7 %). Le repas est presque toujours pris seul (77,8 %). À l'inverse, une ressource existe : la moitié des répondants cuisinent en cellule (49,2 %), ce qui montre des savoir-faire et une envie de « faire comme à la maison ». Une minorité perd du poids (7,5 %) : il ne faut pas l'oublier (anxiété, refus des repas, addictions), car elle relève d'un repérage individuel par l'USMP.

Type de besoin (Bradshaw, 1972)	Dans la situation
Normatif	Prise de poids rapide observée par l'USMP ; repères de l'OMS (2015) et de Santé publique France (2019) sur les sucres et les boissons sucrées non respectés
Ressenti	Faim le soir, ennui, besoin de se calmer, manque d'activité
Exprimé	Demandes de fruits moins chers et qui se conservent ; envie de cuisiner à plusieurs ; inscriptions en liste d'attente pour le sport

Type de besoin (Bradshaw, 1972)	Dans la situation
Comparatif	Rythme imposé très différent de celui de la population générale (dîner à 17 h 30)

Question 2 – Structure des prises et rythmes (2 pts)

Calcul posé – Carnets de 12 détenus

- Total des prises : 5 + 7 + 6 + 8 + 4 + 6 + 9 + 5 + 7 + 6 + 8 + 5 = 76 ; moyenne = 76 / 12 = **6,3 prises par jour**.
- Total des prises hors des trois prises prévues : 2 + 4 + 3 + 5 + 1 + 3 + 6 + 2 + 4 + 3 + 5 + 2 = 40 ; moyenne = 40 / 12 = **3,3 prises hors repas par jour**.
- Part des prises hors repas : 40 / 76 × 100 = **52,6 %**.
- Durée du jeûne pour un détenu qui ne consomme pas le kit : du dîner à 17 h 30 au déjeuner de 11 h 30 le lendemain = 6 h 30 + 11 h 30 = **18 heures**. Avec le kit pris à 7 h 30, l'intervalle entre le dîner et le petit-déjeuner est de **14 heures**.

Analyse. La structure des prises est **déséquilibrée** : plus de la moitié des prises (52,6 %) ont lieu en dehors des repas prévus, et l'échantillon va de 1 à 6 prises hors repas par jour. Le **rythme imposé** (dîner très tôt, petit-déjeuner remis la veille) crée un long intervalle sans repas structuré ; la faim du soir (Karim) est en partie une conséquence de cet horaire, pas seulement un manque de volonté. On observe une forme de **déstructuration** au sens de la sociologie de l'alimentation : les prises ne sont plus organisées par des repas partagés à heures fixes, mais par l'ennui, la télévision, le sommeil décalé (Sofiane dort jusqu'à midi). Les prises hors repas sont souvent des produits denses en énergie (biscuits, sodas), achetés à la cantine.

Limites – Ce que les carnets ne disent pas

Douze volontaires sur trois jours ne représentent pas les 420 détenus. Le nombre de prises ne dit rien des quantités ni de l'énergie. Les détenus qui acceptent de tenir un carnet sont sans doute les plus motivés. À l'oral, présentez ces résultats comme une illustration, pas comme une mesure.

Question 3 – Analyse des pratiques et problème central (2 pts)

Notion du chapitre	Ce que l'on observe	Conséquence pour l'action
Rôles de l'acte alimentaire	Le repas est « le seul moment où il se passe quelque chose » : rôle d'occupation, de repère dans la journée, de plaisir ; cuisiner avec un codétenu restaure un rôle **social** et **identitaire** (« comme à la maison »)	S'appuyer sur la cuisine en cellule et le partage plutôt que sur l'interdiction
Régulation et dérégulation	Manger par ennui ou pour se calmer (54,8 %) : **alimentation émotionnelle** ; signaux de faim et de rassasiement brouillés par l'inactivité et la télévision	Travailler avec le psychologue les autres réponses à l'ennui et au stress ; repérer faim et envie de manger
Déterminants individuels	Stress de l'incarcération, sommeil perturbé, sevrage tabagique ou d'autres substances pour certains, baisse d'activité physique (David)	Activité physique en cellule et accès au sport ; orientation individuelle par l'USMP
Déterminants environnementaux	Horaires imposés, offre de la cantine (biscuits et sodas faciles, fruits chers et fragiles), équipement limité (plaque, petit réfrigérateur)	Agir avec la direction et le prestataire sur l'offre et les prix de la cantine
Dimension sociale du repas	Repas pris seul (77,8 %) ; la convivialité apparaît seulement quand on cuisine à deux	Ateliers collectifs de cuisine « à la plaque » ; partage de recettes entre détenus

Problème central : à la maison d'arrêt de Montrevel, plus de la moitié des détenus entrants (55,0 %) prennent au moins 5 % de leur poids en six mois, dans un contexte de rythme alimentaire imposé, de prises hors repas fréquentes et d'alimentation liée à l'ennui. **Causes** : dîner très tôt et long jeûne nocturne ; ennui et stress ; repas pris seul ; offre de la cantine riche en produits sucrés et gras ; peu d'activité physique ; manque de solutions pour cuisiner simplement en cellule. **Conséquences** : prise de poids, risque de diabète et de maladies cardio-vasculaires, mal-être et image de soi dégradée, difficultés à la sortie si les habitudes se maintiennent.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Réduire le problème à un manque de volonté ; proposer de « supprimer les biscuits de la cantine » sans concertation ni alternative ; oublier que le dîner à 17 h 30 est une contrainte de l'établissement ; parler de « régime » ; proposer une activité qui suppose internet ou des objets interdits (couteaux, bocaux en verre).

Question 4 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : d'ici octobre 2027, favoriser des pratiques alimentaires plus structurées et plus favorables à la santé chez les personnes détenues à la maison d'arrêt de Montrevel, afin de limiter la prise de poids au cours de la détention.
- **Objectif spécifique 1** : d'ici octobre 2027, réduire de 56,3 % à 45 % au plus la part des détenus qui grignotent le soir au moins 5 soirs sur 7.
- **Objectif spécifique 2** : d'ici octobre 2027, réduire de 55,0 % à 40 % au plus la part des entrants qui prennent au moins 5 % de leur poids en six mois.
- **Objectifs opérationnels** : animer 8 ateliers « cuisiner à la plaque » de 6 détenus entre janvier et juin 2027 (indicateur : nombre d'ateliers et de participants ; cible : 48 participations) ; former 6 détenus relais avant février 2027 (feuilles de présence) ; obtenir de la direction et du prestataire l'ajout d'au moins 5 produits favorables à la cantine (fruits de garde, compotes sans sucres ajoutés, conserves de légumineuses et de légumes, eau aromatisée sans sucre) avant mars 2027 (bon de commande de la cantine) ; distribuer un livret « bouger en cellule » à 100 % des entrants à partir de janvier 2027 (registre de l'accueil) ; mettre en place 6 séances « ennui, stress et alimentation » avec le psychologue de l'USMP avant juin 2027 (nombre de séances et de participants).

Question 5 – Plan d'action et budget (1,5 pt)

Action	Contenu	Notion du chapitre mobilisée
1. Ateliers « cuisiner à la plaque »	Recettes simples avec les produits de la cantine (lentilles en conserve, œufs, légumes de garde, riz), préparées à deux ou à trois, puis partagées	Rôle **social** et **identitaire** du repas ; savoir-faire ; plaisir
2. Détenus relais	6 volontaires formés : recettes, repères simples, écoute ; ils animent une partie des ateliers et diffusent les recettes à leurs codétenus	Influence des pairs ; légitimité d'un message porté par le groupe
3. Offre de la cantine	Groupe de travail direction, prestataire, USMP et relais : ajout de produits favorables, présentation qui les met en valeur, dégustations	Déterminants **environnementaux** : rendre le choix favorable plus facile
4. « Le soir sans faim »	Fiche et atelier : fractionner le dîner (garder le fruit ou le laitage pour 20 h), collations rassasiantes, boissons sans sucre	**Rythme** et **structure des prises** : adapter la prise du soir à l'horaire imposé
5. « Ennui, stress et alimentation »	Séances animées avec le psychologue : repérer faim et envie de manger, autres réponses à l'ennui (lecture, exercices, écriture)	**Alimentation émotionnelle** ; régulation

Action	Contenu	Notion du chapitre mobilisée
6. « Bouger en cellule »	Livret illustré d'exercices sans matériel, remis à l'accueil ; plaidoyer pour élargir l'accès à la salle de sport	Équilibre entre apports et dépenses ; plaisir de bouger

Calcul posé – Budget prévisionnel (prix construits pour le sujet)

- Denrées des ateliers : 8 ateliers × 6 détenus × 3,00 € = **144,00 €**.
- Matériel des séances « ennui, stress et alimentation » (cartes, affiches) : **60,00 €**.
- Livret « bouger en cellule » : 420 exemplaires × 0,40 € = **168,00 €**.
- Formation des 6 détenus relais (supports, attestations) : **100,00 €**.
- Supports de communication (livret de recettes à la plaque illustré, traduit en trois langues, affiches) : **380,00 €**.
- Petit matériel autorisé par l'administration (boîtes, ustensiles en plastique, épluche-légumes adaptés) : **300,00 €**.
- Dégustations de nouveaux produits de cantine : 5 × 40,00 € = **200,00 €**.
- Sous-total : 144 + 60 + 168 + 100 + 380 + 300 + 200 = **1 352,00 €**.
- Imprévus : 1 500 − 1 352 = **148,00 €**, soit 148 / 1 500 × 100 = **9,9 %** du budget.

Total : **1 500,00 €**.

Évaluation (à présenter à l'oral) : **processus** (nombre d'ateliers, de participants, de relais formés, de produits ajoutés à la cantine, respect du budget) ; **résultats** (part des détenus qui grignotent le soir, achats de boissons sucrées d'après les relevés de la cantine, même questionnaire en octobre 2027) ; **impact** (part des entrants qui prennent au moins 5 % de leur poids en six mois, d'après les données agrégées et anonymes de l'USMP).

Partie B – Recherche appliquée

Question 6 – Risque relatif et intervalle de confiance (1,5 pt)

Calcul posé – Risque relatif de prise de poids d'au moins 5 % selon l'achat de boissons sucrées

- Acheteurs de boissons sucrées : a = 32 ; a + b = 48 ; risque = 32 / 48 = 0,667, soit **66,7 %**.
- Non-acheteurs : c = 12 ; c + d = 32 ; risque = 12 / 32 = 0,375, soit **37,5 %**.
- RR = 0,667 / 0,375 = **1,78**.
- ln RR = ln 1,78 = 0,575.
- Erreur type = √(1/32 − 1/48 + 1/12 − 1/32) = √(0,03125 − 0,02083 + 0,08333 − 0,03125) = √0,0625 = **0,25**.
- Bornes : exp(0,575 − 1,96 × 0,25) = exp(0,085) = **1,09** ; exp(0,575 + 1,96 × 0,25) = exp(1,065) = **2,90**.
- IC 95 % du RR = **[1,09 ; 2,90]**.

Vérification : 48 + 32 = 80 entrants ; 32 + 12 = 44 entrants qui ont pris au moins 5 %, comme dans le document 3.

Interprétation : les détenus qui achètent des boissons sucrées chaque semaine ont **1,8 fois plus de risque** de prendre au moins 5 % de leur poids en six mois. L'intervalle de confiance ne contient pas 1 : l'association est **statistiquement significative** au seuil de 5 %, mais l'intervalle est large (de 1,09 à 2,90), car les effectifs sont petits. On ne peut pas conclure à une **causalité** : l'achat de boissons sucrées peut être le marqueur d'autres facteurs (ennui, grignotage, moindre activité, revenus plus élevés permettant d'acheter à la cantine) ; ces **facteurs de confusion** n'ont pas été contrôlés ; l'achat de boissons sucrées et la prise de poids ont été relevés dans la même période. Le résultat est cependant **cohérent** avec les connaissances (repères de l'OMS sur les sucres libres) et justifie d'agir sur l'offre de boissons.

Question 7 – Intervalle de confiance, taille d'échantillon et limites des carnets (1,5 pt)

Calcul posé – Proportion de détenus qui grignotent le soir

p = 71 / 126 = 0,5635 ; n = 126.

Erreur type = √(0,5635 × 0,4365 / 126) = √0,001952 = 0,0442.

Marge = 1,96 × 0,0442 = 0,087, soit **8,7 points**.

IC 95 % = [56,3 − 8,7 ; 56,3 + 8,7] = **[47,7 % ; 65,0 %]**.

Taille pour ± 5 points : n = 1,96² × 0,5635 × 0,4365 / 0,05² = 3,8416 × 0,2460 / 0,0025 = **378,0**.

Correction pour une population de 420 : n' = 378,0 / (1 + 377,0 / 420) = 378,0 / 1,898 = **199,2**, soit **200** détenus.

Avec 126 répondants, la précision est de ± 8,7 points : la borne basse (47,7 %) est inférieure à 50 %, on ne peut donc pas affirmer avec certitude qu'une **majorité** des détenus grignotent le soir ; on peut dire qu'environ un détenu sur deux est concerné.

Limites des carnets dans ce contexte :

- **Sous-déclaration** et **désirabilité sociale** : un document remis à l'USMP peut être perçu comme lié à la surveillance ou au dossier ; les prises jugées « mauvaises » sont oubliées ou cachées.
- **Niveau de lecture et d'écriture** variable, langues différentes : un carnet écrit exclut une partie du public ; il faut des pictogrammes ou une aide.
- **Biais de sélection** : volontaires, sans doute plus motivés ; trois jours seulement, qui ne tiennent pas compte des jours de parloir ou de cantine.
- **Effet de l'observation** : le simple fait de noter modifie le comportement (on grignote moins quand on sait qu'on note).

Partie C – Veille

Question 8 – Organiser une veille (2 pts)

- **Besoins** : santé des personnes détenues ; alimentation et restauration en milieu pénitentiaire ; interventions sur le grignotage, l'alimentation émotionnelle et l'activité physique en milieu fermé ; réglementation (code pénitentiaire, règles pénitentiaires européennes).
- **Sources fiables** : ministère de la Justice (direction de l'administration pénitentiaire, statistiques mensuelles) ; ministère de la Santé (feuille de route santé des personnes placées sous main de justice) ; Santé publique France ; Fédération Promotion Santé et structures régionales ; Contrôleur général des lieux de privation de liberté (rapports de visite, qui décrivent souvent l'alimentation) ; Conseil de l'Europe (règles pénitentiaires européennes) ; OMS Europe (programme santé en prison) ; bases bibliographiques (PubMed, Cairn).
- **Outils** : alertes par courriel et flux RSS ; lettres d'information ; tableau de veille partagé avec l'USMP (date, source, résumé, utilité, décision).
- **Fréquence** : une heure par semaine, une synthèse mensuelle.
- **Diffusion** : note d'une page à l'équipe de l'USMP ; point en réunion de service ; transmission au groupe de travail sur la cantine.

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique

Question 9 – Les trois situations du document 5 (1,5 pt)

- **La liste des détenus « en obésité »** : refus. Le poids et le diagnostic d'obésité sont des **données de santé**, couvertes par le **secret médical** et le secret professionnel des soignants de l'USMP (article L. 1110-4 du code de la santé publique) ; ils ne peuvent pas être transmis à l'administration pénitentiaire. L'intention est bonne : on propose plutôt que l'accès au sport soit élargi à tous, et que l'USMP puisse **orienter** elle-même, avec l'accord du détenu, ceux qui en ont besoin.
- **L'usage commercial des résultats** : refus. Les données ont été recueillies pour un projet de santé publique, avec une finalité annoncée aux répondants ; les utiliser pour une plaquette commerciale serait un **détournement de finalité** (principe de limitation des finalités du RGPD) et pourrait laisser croire que l'USMP

recommande ce prestataire. On peut, en revanche, partager avec le prestataire des résultats **agrégés** utiles à l'amélioration de la cantine, dans le cadre du groupe de travail.

- **Le reportage photo** : il est soumis à l'**autorisation de la direction** de l'établissement et au **consentement écrit** de chaque personne photographiée ; les personnes détenues ont droit au respect de leur image et de leur vie privée, et leur identification peut leur nuire à la sortie. On propose des photos des mains, des plats et des ustensiles, sans visage, et un texte rédigé avec les détenus relais.
- **Réponses proposées (exemples)** : au surveillant : « Je ne peux pas vous transmettre ces informations, elles sont couvertes par le secret médical. En revanche, nous pouvons proposer ensemble à la direction d'élargir l'accès au sport, et l'USMP orientera les personnes qui le souhaitent. » Au prestataire : « Les réponses ont été recueillies pour l'USMP et ne peuvent pas servir à une plaquette commerciale ; nous partagerons volontiers les résultats globaux dans le groupe de travail sur la cantine. » Au journaliste : « Le reportage dépend de l'accord de la direction ; s'il a lieu, aucune personne ne sera reconnaissable. »

Question 10 – Communication, exposé et questions du jury (1,5 pt)

Supports adaptés : affiches et livret de recettes **illustrés** (photos des étapes, pictogrammes), phrases courtes, traduits dans les langues les plus parlées ; diffusion par le **canal vidéo interne** quand il existe, par les détenus relais et lors de l'accueil des arrivants ; messages positifs et concrets (« Garder son fruit pour 20 h », « Cuisiner à deux, c'est meilleur ») ; aucun message sur le poids affiché collectivement.

Préparer l'oral – Trame de l'exposé de 10 minutes

0 – 1 min : le contexte (maison d'arrêt, USMP) et la demande. 1 – 3 min : les pratiques observées (questionnaire, suivi du poids, carnets) et leur logique (rythme imposé, ennui, solitude). 3 – 4 min : problème central et besoins. 4 – 5 min : objectifs. 5 – 7 min : plan d'action, partenaires, budget. 7 – 8 min : évaluation et ce que j'ai réalisé pendant le stage. 8 – 9 min : éthique (secret médical, finalité des données, droit à l'image). 9 – 10 min : bilan personnel.

Questions probables du jury – Questions probables et réponses attendues

1. Qu'est-ce qu'une prise hors repas ? Une prise alimentaire en dehors des repas structurés ; on distingue la collation prévue et le grignotage non planifié.
2. Pourquoi ne pas interdire les sodas à la cantine ? Ce n'est pas du ressort du diététicien ; une interdiction sans alternative crée frustration et marché parallèle ; on agit avec la direction sur l'offre et les prix.
3. Qu'est-ce que l'alimentation émotionnelle ? Manger en réponse à une émotion (ennui, stress, tristesse) plutôt qu'à la faim.
4. Votre RR prouve-t-il que les sodas font grossir ? Non : association significative mais pas causalité ; facteurs de confusion possibles.
5. Comment avez-vous calculé l'intervalle de confiance du RR ? Méthode logarithmique, avec l'erreur type de ln RR.
6. Pourquoi votre taille d'échantillon est-elle corrigée ? La population est petite (420) : la correction pour population finie réduit le nombre nécessaire.
7. Pourquoi associer des détenus relais ? Crédibilité des pairs, connaissance des règles informelles, participation.
8. Comment adaptez-vous vos supports ? Pictogrammes, photos, langues, phrases courtes.
9. Que faites-vous si un détenu perd beaucoup de poids ? Je le signale à l'équipe soignante de l'USMP, qui évalue la situation.
10. Qui décide des horaires des repas ? L'administration pénitentiaire ; on peut proposer des adaptations (fractionner le dîner), pas les imposer.
11. Que dit le secret médical face à l'administration ? Les informations de santé ne sont pas transmises sans l'accord du patient, sauf exceptions prévues par la loi.
12. Quels produits ajouter à la cantine ? Fruits de garde, compotes sans sucres ajoutés, conserves de légumineuses et de légumes, laitages, eau aromatisée sans sucre.

13. Comment évaluer l'effet sur le poids ? Données agrégées et anonymes de l'USMP, comparées à l'année précédente, avec prudence.
14. Pourquoi parler de rythme et pas seulement de calories ? Le long jeûne du soir et la faim tardive expliquent en partie le grignotage.
15. Comment préparer la sortie ? Lien avec le SPIP, recettes simples et économiques, adresses de l'aide alimentaire et des ateliers de quartier.

Grille d'évaluation et barème

Partie	Indicateurs du référentiel évalués	Points
A – Projet	Analyse et diagnostic de situation posé (indicateurs, structure des prises, logique des pratiques) ; objectifs formulés et adaptés ; plan d'action justifié et réaliste ; budget (C3.1)	9
B – Recherche	Traitement et analyse des données (RR et son intervalle, IC d'une proportion, taille d'échantillon) ; limites des carnets ; prudence sur la causalité (C3.3)	3
C – Veille	Besoins identifiés ; sources fiables ; outils et diffusion (C3.4)	2
D – Communication et numérique	Supports adaptés ; secret médical ; finalité des données ; droit à l'image (C3.5, C3.6)	3
Expression	Expression écrite et orale maîtrisée ; vocabulaire ; sources datées	3
Total		20

Niveaux de maîtrise pour chaque partie : non maîtrisé (moins de 25 % des points), insuffisamment maîtrisé (25 à 49 %), maîtrisé (50 à 79 %), bien maîtrisé (80 % et plus).

Corrigé S2 – « Fait maison en 30 minutes » : un atelier pour des parents qui élèvent seuls leurs enfants

que le jury attend

Le jury attend un atelier qui montre, chronomètre en main, qu'un repas maison peut être rapide, apprécié des enfants et d'un coût proche de celui des produits habituels, sans culpabiliser les parents. Il évalue la justesse des calculs (quantités brutes, coût, apports Ciqual), la comparaison honnête avec le repas habituel, la maîtrise des allergènes et de l'hygiène de la volaille, et la qualité de l'animation en binômes. Il pénalise les discours moralisateurs sur les produits industriels et les adaptations approximatives de l'allergie à l'œuf.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Besoins et objectifs (2 pts)

Besoins **pratiques** : gagner du temps (horaires décalés, fatigue), rester dans un budget serré, trouver des recettes que les enfants acceptent. Besoins **psychologiques** : être reconnus comme de « bons parents » malgré les contraintes, alléger la **culpabilité** (« je sais que ce n'est pas bien ») et la charge mentale, reprendre confiance en leurs capacités (deux mères disent ne rien savoir faire). Besoins **sociaux** : rompre l'isolement, échanger des astuces entre parents. Besoins **nutritionnels** : limiter le sel et les matières grasses des produits ultra-transformés consommés plusieurs fois par semaine, garder des repas riches en protéines et en légumes pour les enfants.

- **Objectif général** : permettre à des parents qui élèvent seuls leurs enfants de préparer en 30 minutes un repas maison apprécié de la famille, d'un coût comparable à celui des produits prêts à consommer.
- **Objectifs opérationnels** : à la fin de l'atelier, chaque parent aura réalisé lui-même au moins deux étapes de la recette (panure, cuisson de la purée, compote) (observation) ; aura comparé l'étiquette d'un produit habituel et la recette maison avec la grille fournie (grille remplie) ; repartira avec la fiche « famille » et la fiche « deux soirs » (fiches remises) ; aura indiqué sur la grille d'évaluation s'il pense refaire la recette dans les quinze jours.

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 10 portions

Quantité nette totale = grammage net × 10 ; quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte) ; coût = quantité brute en kg × prix au kg.

Denrée	Quantité nette	Quantité brute	Unité de commande	Prix unitaire	Coût
Filets de poulet sans peau (halal)	1 000 g	1 000 g	1,000 kg	11,90 € le kg	11,90 €
Pétales de maïs nature	200 g	200 g	0,200 kg	4,20 € le kg	0,84 €
Œufs	100 g	2 œufs	2 pièces	0,30 € l'œuf	0,60 €
Farine T55	80 g	80 g	0,080 kg	1,10 € le kg	0,09 €
Huile de colza	50 g	50 g	0,050 kg	3,20 € le kg	0,16 €
Pommes de terre	1 200 g	1 200 / 0,80 = 1 500 g	1,500 kg	1,20 € le kg	1,80 €
Carottes	1 000 g	1 000 / 0,85 = 1 176,5 g	1,177 kg	1,50 € le kg	1,76 €
Lait demi-écrémé UHT	400 g	400 g	0,400 kg	1,05 € le kg	0,42 €
Beurre doux	50 g	50 g	0,050 kg	9,50 € le kg	0,48 €
Pommes	800 g	800 / 0,80 = 1 000 g	1,000 kg	2,40 € le kg	2,40 €
Bananes	400 g	400 / 0,65 = 615,4 g	0,615 kg	2,00 € le kg	1,23 €
Paprika, ail, sel, poivre, cannelle, papier sulfurisé	–	–	forfait	–	0,60 €

Denrée	Quantité nette	Quantité brute	Unité de commande	Prix unitaire	Coût
Total					22,28 €

Coût par portion = 22,28 / 10 = **2,23 €**, inférieur au plafond de 2,50 € : le budget est respecté, avec une marge de 0,27 € par portion. Le poulet représente 11,90 / 22,28 × 100 = **53,4 %** du coût.

Repas habituel (document 5) : 1,29 + 0,45 + 0,30 = **2,04 €** par portion. Le repas maison coûte **0,19 € de plus** par portion, soit + 9,3 % : l'écart est faible et peut être réduit (cuisses de poulet désossées, achat de poulet entier découpé, fruits de saison).

Question 3 – Fiche technique, fiche « famille », adaptations et version « deux soirs » (3 pts)

Modèle – Fiche technique des nuggets de poulet maison (10 portions)

Ingrédients : filets de poulet 1 kg ; pétales de maïs nature 200 g ; œufs 2 ; farine 80 g ; huile de colza 50 g ; paprika doux, ail en poudre, poivre ; sel : une pincée.

Matériel : planche réservée aux viandes crues (couleur dédiée), couteau d'office, trois assiettes creuses, sac de congélation ou bol et rouleau à pâtisserie, plaques de four, papier sulfurisé, pinceau, pince, thermomètre à sonde, bacs gastronormes.

Étapes : 1) Préchauffer le four à 200 °C. 2) Écraser les pétales de maïs en chapelure grossière (sac fermé et rouleau) ; ajouter paprika et ail. 3) Couper les filets en lanières d'environ 2 cm sur 5 cm, de taille régulière. 4) Paner à l'anglaise : farine, œuf battu, pétales ; une main « sèche » et une main « mouillée ». 5) Déposer sur plaque garnie de papier, badigeonner d'huile au pinceau. 6) Cuire 15 à 18 minutes en retournant à mi-cuisson. 7) Vérifier la cuisson à cœur sur la plus grosse pièce. 8) Servir aussitôt ou maintenir au chaud au-dessus de 63 °C.

Points critiques : volaille crue (contamination croisée : planche et couteau dédiés, lavage des mains après chaque manipulation, ne pas rincer le poulet) ; œuf cru (casser à part, se laver les mains) ; cuisson à cœur sans partie rosée ; allergènes (œuf, gluten, lait) ; taille régulière pour une cuisson homogène.

Fiche « famille » (une page, photos des étapes) : « 30 minutes, 4 étapes : 1. Four à 200 °C. 2. J'écrase les pétales. 3. Je coupe et je panne. 4. 15 minutes au four. Pendant ce temps : la purée et la compote au micro-ondes. » Avec une liste de courses pour 4 personnes (400 g de poulet, 80 g de pétales, 1 œuf…) et le coût.

Adaptations :

- **Fils de Madame T. (allergie à l'œuf)** : remplacer l'œuf par du **lait** (ou un yaourt nature) pour faire adhérer la panure ; préparer sa portion **en premier**, avec des ustensiles propres réservés, sur une plaque séparée, et l'étiqueter ; vérifier l'étiquette des pétales de maïs (mentions « peut contenir ») ; informer la mère de chaque ingrédient (règlement INCO).
- **Madame B. (halal)** : le poulet est commandé **halal** au même prix pour tout le groupe, ce qui évite une préparation séparée ; aucun ingrédient de la recette ne contient d'alcool ni de porc.
- **Fils de Monsieur K. (3 ans)** : couper les nuggets en **petits morceaux** ou les effilocher, purée lisse et **sans sel ajouté**, compote lisse ; portion environ de moitié ; surveiller le repas (risque de fausse route avec des morceaux durs).
- **Version « cuisiner une fois pour deux soirs »** : doubler les quantités ; congeler à plat les nuggets **panés crus** sur une plaque, puis en sac étiqueté (date, contenu) à − 18 °C, à consommer dans les 3 mois ; les cuire **sans décongélation** à 200 °C, 20 à 25 minutes, en vérifiant la cuisson à cœur ; purée en portions au congélateur ; compote 48 heures au réfrigérateur.

Question 4 – Apports, comparaison et classification NOVA (2 pts)

Calcul posé – Apport d'une portion du repas maison (poids nets crus, Ciqual 2025)

Préparation	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Nuggets maison	271,4	26,8	22,4	0,95	7,7	1,18	0,51
Purée carottes-pommes de terre	182,9	4,6	26,6	7,8	4,9	5,54	0,16
Compote minute pomme-banane	76,1	0,6	17,4	15,4	0,2	2,99	0,01
Repas maison	**530,4**	**32,0**	**66,4**	**24,1**	**12,8**	**9,71**	**0,67**
Repas habituel	**667,4**	**24,8**	**78,7**	**28,0**	**26,7**	**7,89**	**3,04**

Exemple de calcul : poulet 100 × 110 / 100 = 110,0 kcal ; pétales 20 × 372 / 100 = 74,4 kcal ; œuf 10 × 140 / 100 = 14,0 kcal ; farine 8 × 350 / 100 = 28,0 kcal ; huile 5 × 900 / 100 = 45,0 kcal ; total nuggets 271,4 kcal. Sel des pétales : 20 × 1,82 / 100 = 0,36 g.

Répartition de l'énergie du repas maison : protéines 32,0 × 4 / 530,4 = **24,2 %** ; glucides 66,4 × 4 / 530,4 = **50,1 %** ; lipides 12,8 × 9 / 530,4 = **21,7 %** (le reste vient surtout des fibres).

Repas habituel : protéines 24,8 × 4 / 667,4 = **14,8 %** ; glucides 78,7 × 4 / 667,4 = **47,2 %** ; lipides 26,7 × 9 / 667,4 = **36,0 %**.

Comparaison. Pour un coût proche, le repas maison apporte **137 kcal de moins**, **7,3 g de protéines de plus**, **deux fois moins de lipides** (12,8 g contre 26,7 g) et surtout **2,37 g de sel en moins** (0,67 g contre 3,04 g, soit − 78,0 %) : le repas habituel apporte à lui seul 61 % de la limite de 5 g de sel par jour de l'OMS. Les sucres sont proches (24,1 g contre 28,0 g), mais ceux de la compote minute viennent des fruits, sans sucre ajouté, alors que la compote préemballée standard contient du sucre ajouté. Le repas maison apporte aussi plus de fibres (9,7 g contre 7,9 g).

Ingrédient ou produit	Groupe NOVA	Commentaire
Poulet, œuf, pommes de terre, carottes, lait, pommes, bananes, farine	1	Aliments pas ou peu transformés
Huile, beurre, sel	2	Ingrédients culinaires
Pétales de maïs nature	3 ou 4 selon la liste d'ingrédients	Produit industriel qui contient souvent du sucre, du sel et de l'extrait de malt d'orge
Nuggets préemballés, purée en flocons	4 en général	Formulations industrielles avec des ingrédients et des additifs peu utilisés à la maison
Compote préemballée standard	3 en général	Fruits et sucre ajouté

La place des pétales de maïs : ils apportent du croustillant que les enfants aiment, mais ils sont eux-mêmes transformés et salés (0,36 g de sel par portion, soit 71 % du sel des nuggets maison). On peut les remplacer par de la **chapelure maison** (pain rassis mixé, ce qui lutte aussi contre le gaspillage) ou des **flocons d'avoine** (groupe 1). L'objectif n'est pas la « pureté » mais de **réduire la part** des produits ultra-transformés dans la semaine.

Question 5 – Pourquoi ces achats, et comment aider sans culpabiliser (2 pts)

Notion du chapitre	Ce que l'on observe	Ce que l'atelier propose
Déterminants	Temps contraint (horaires décalés), fatigue, budget, offre de produits prêts à l'emploi, marketing destiné aux enfants	Recettes en 30 minutes, coût calculé, astuces d'organisation
Charge mentale et rôle nourricier	Le parent seul porte toutes les décisions et toutes les tâches	Fiche « deux soirs », congélation, liste de courses prête

Notion du chapitre	Ce que l'on observe	Ce que l'atelier propose
Mangeur pluriel	Les familles combinent produits prêts, plats maison, repas rapides selon les jours	Montrer qu'on peut alterner, sans tout changer
Plaisir et acceptation des enfants	Les enfants aiment les nuggets : c'est une ressource	Garder la forme appréciée, changer la recette
Injonctions et culpabilité	« Je sais que ce n'est pas bien » : la multiplication des normes crée un sentiment d'échec	Valoriser ce que les parents font déjà, ne pas diaboliser les produits, présenter les comparaisons comme des informations

Limites : un atelier unique ne change pas les horaires de travail ni les revenus. Il doit s'inscrire dans un cycle (cuisine de base, courses, conservation) et dans l'action de l'association (garde d'enfants, entraide entre parents).

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté des 3 heures (2 pts)

Horaire	Candidat	Participants
9 h 00 – 9 h 30	Contrôle des denrées (températures, dates), mise en place des 4 postes, préchauffage du four, préparation des grilles et du chronomètre	–
9 h 30 – 9 h 45	Accueil, café ; tour de table « un repas que mes enfants adorent » ; consignes d'hygiène	Lavage des mains, tablier
9 h 45 – 9 h 55	Animation de la comparaison des étiquettes (nuggets, purée en flocons, compote)	Lecture en binômes avec la grille
9 h 55 – 10 h 25	Lancement du chronomètre « 30 minutes » ; démonstration de la panure ; supervision	Binômes 1 et 2 : nuggets (dont la portion sans œuf en premier) ; binôme 3 : purée ; binôme 4 : compote au four à micro-ondes, puis aide à la panure
10 h 10 – 10 h 28	Enfournement, contrôle de la cuisson à cœur	Rangement des postes au fur et à mesure
10 h 25 – 10 h 45	Débriefing « Combien de temps avons-nous mis ? » ; démonstration de la version « deux soirs » et de la congélation	Questions, échanges d'astuces
10 h 45 – 11 h 00	Dressage d'une assiette adulte et d'une assiette pour 3 ans	Préparation de la table
11 h 00 – 11 h 40	Repas avec les enfants ; dégustation	Grille parents ; grille enfants à visages
11 h 40 – 12 h 00	Bilan, évaluation, remise des fiches	Remplissage de la grille d'évaluation

La remise en état (vaisselle, nettoyage et désinfection des plans de travail, tri des déchets) est organisée de 11 h 40 à 12 h 00 avec les volontaires, puis terminée par le candidat dans le temps restant de l'épreuve.

Question 7 – Méthodes, outils et grilles (1,5 pt)

Méthodes : **démonstration** courte puis **pratique** en binômes (un parent qui sait faire avec un parent qui débute) ; **chronomètre** visible pour objectiver le temps réel ; comparaison d'étiquettes en petits groupes, présentée comme une information et non comme un jugement ; valorisation des astuces des parents. Outils : fiche recette illustrée, liste de courses pour 4 personnes, grille de lecture d'étiquette (sel, lipides, liste d'ingrédients), fiche « deux soirs ». Grille de dégustation parents : aspect, goût, croustillant, « mes enfants aimeront » (1 à 5), « je referai » (oui / peut-être / non). Grille enfants : trois visages (j'aime, un peu, pas du tout) pour les nuggets, la purée et la compote.

Question 8 – Hygiène, allergènes et éco-gestes (1,5 pt)

Règle des **5 M** : matière (contrôle des dates et des températures du poulet à réception), main-d'œuvre (lavage des mains, tenue, cheveux attachés), matériel (planches de couleur, thermomètre), milieu (plans désinfectés,

marche en avant), méthode (panure puis cuisson sans attente à température ambiante). **Volaille** : ne pas rincer, éviter les contaminations croisées, cuire à cœur. **Œuf** : casser à part, se laver les mains. **Congélation** : produits refroidis, étiquetés, − 18 °C, jamais recongelés après décongélation. **Allergènes** : œuf, gluten (farine, et souvent extrait de malt d'orge dans les pétales de maïs), lait (lait, beurre) ; tableau des allergènes affiché ; portion sans œuf préparée en premier et étiquetée. **Éco-gestes** : légumes de saison, épluchures au compost, chapelure de pain rassis, cuisson de plusieurs plaques en une seule fois au four, vaisselle réutilisable.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (3 pts)

Nuggets dorés et croustillants, cuits à cœur, de taille régulière ; purée lisse, assaisonnée avec modération ; compote cuite, sans sucre ajouté. Assiette adulte : 6 à 7 nuggets, purée, compote en coupelle. Assiette 3 ans : nuggets coupés en petits morceaux, purée lisse sans sel ajouté, compote. Respect du temps, de l'hygiène et de l'ordre des postes.

Question 10 – Évaluation (1 pt)

Satisfaction (grilles de dégustation parents et enfants) ; acquis (chaque parent sait-il nommer deux différences entre l'étiquette des nuggets industriels et la recette maison ?) ; **temps réel** de préparation mesuré au chronomètre ; intention de refaire dans les quinze jours ; à la séance suivante, « Avez-vous refait la recette ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ? ».

Barème – Barème du sujet

Conception 11 (besoins et objectifs 2 ; bon de commande 2 ; fiche technique et adaptations 3 ; apports et NOVA 2 ; analyse 2) ; organisation et animation 5 ; réalisation et évaluation 4 ; total 20.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Oublier les pertes des bananes (35 %) ou des carottes ; compter l'œuf en grammes sans vérifier le nombre d'œufs ; diaboliser les produits industriels devant les parents ; préparer la portion sans œuf après les autres, avec les mêmes ustensiles ; oublier le gluten caché des pétales de maïs ; décongeler les nuggets crus à température ambiante.

Corrigé S3 – « Loin de tout, mais pas sans ressources » : pratiques alimentaires dans une communauté de communes rurale

que le jury attend

Le jury attend une analyse qui ne réduit pas le territoire rural à un « désert alimentaire » : il faut décrire à la fois les difficultés d'accès et les ressources (potagers, conserves, vente directe, solidarités, savoir-faire des aînés), puis construire avec les habitants des actions qui valorisent ces ressources. Il évalue la justesse des calculs (indicateurs, score de diversité, bon de commande, apports), la prudence dans l'interprétation, et un atelier qui fait des participants des transmetteurs de savoir-faire.

Temps 1

Question 1 – Indicateurs, score de diversité et limites (4 pts)

Calcul posé – Indicateurs de l'enquête (n = 150 ménages)

- Sans voiture : 21 / 150 × 100 = **14,0 %**.
- Personne de référence de 60 ans ou plus : 71 / 150 × 100 = **47,3 %**.
- Potager : 87 / 150 × 100 = **58,0 %**.
- Conserves ou congélations de produits du jardin : 64 / 150 × 100 = **42,7 %**.
- Achat direct à un producteur au moins une fois par mois : 52 / 150 × 100 = **34,7 %**.
- Légumes secs au moins une fois par semaine : 39 / 150 × 100 = **26,0 %**.
- Plats préparés industriels au moins 3 fois par semaine : 33 / 150 × 100 = **22,0 %**.
- Repas du soir à plusieurs chaque jour : 108 / 150 × 100 = **72,0 %**.
- Taux de réponse : 150 / 4 300 × 100 = **3,5 %**.

Calcul posé – Score de diversité alimentaire des ménages (HDDS, sur 12)

- Ménages avec potager : (9 + 8 + 10 + 7 + 9 + 8 + 11 + 9) / 8 = 71 / 8 = **8,9**.
- Ménages sans potager : (6 + 5 + 7 + 6 + 8 + 5) / 6 = 37 / 6 = **6,2**.
- Écart : 8,9 − 6,2 = **2,7 groupes** d'aliments en faveur des ménages qui ont un potager.
- Moyenne des 14 ménages : (71 + 37) / 14 = 108 / 14 = **7,7**.

Interprétation. Le territoire présente des **difficultés d'accès** (14,0 % des ménages sans voiture, dans un territoire où 14 communes sur 21 n'ont plus de commerce) et une population âgée (47,3 % des personnes de référence ont 60 ans ou plus). Mais il dispose de **ressources** importantes : plus de la moitié des ménages ont un potager (58,0 %), plus de quatre sur dix font des conserves ou congèlent leurs récoltes (42,7 %), un tiers achètent à la ferme (34,7 %), et le repas du soir reste très majoritairement partagé (72,0 %). Les légumes secs sont peu consommés (26,0 %), ce qui confirme la perte de savoir-faire évoquée par Mme L. Les ménages avec potager ont en moyenne un score de diversité supérieur de 2,7 groupes, ce qui suggère un lien entre autoproduction et diversité.

Limites : taux de réponse très faible (3,5 %) et **biais de sélection** probable (les personnes qui fréquentent le marché ou l'épicerie itinérante, et les plus intéressées, répondent davantage ; les personnes isolées sans voiture sont sans doute sous-représentées) ; données **déclarées** ; rappel des 24 heures auprès de 14 ménages seulement, sur un seul jour, qui ne tient pas compte de la saison (le potager produit surtout de mai à octobre) ; l'écart de score selon le potager peut s'expliquer par d'autres facteurs (âge, revenu, temps disponible, voiture), qui n'ont pas été contrôlés : on parle d'**association**, pas de causalité.

Question 2 – Analyse des pratiques (3 pts)

Notion du chapitre	Ce que l'on observe	Conséquence pour le projet
Déterminants d'accès physique	Commerces éloignés, dépendance à la voiture ou aux voisins (M. P.) ; achats orientés vers ce qui se garde	Transport solidaire, épicerie itinérante, commandes groupées
Déterminants économiques	Le potager et la vente directe réduisent les dépenses ; les plats préparés coûtent cher	Valoriser l'autoproduction et les produits bruts locaux
Âge et transmission des savoir-faire	Les aînés savent conserver et cuisiner ; une partie des savoir-faire s'est perdue (« c'était ma mère »)	Ateliers intergénérationnels, recueil de recettes
Temps et travail	Les actifs qui travaillent loin rentrent tard (Mme C.) et recourent aux plats préparés	Recettes rapides, plats à préparer à l'avance
Saisonnalité et autoproduction	Abondance l'été (« trop de courgettes »), conserves l'hiver	Ateliers de conservation sûre, trocs et dons de légumes
Dimension sociale du repas	Repas du soir partagé (72,0 %) ; solidarités de voisinage	S'appuyer sur ces liens (club des aînés, repas partagés)
Alimentation durable	Circuits courts, autoproduction, peu d'emballages, mais forte dépendance à la voiture	Inscrire les actions dans le PAT ; limiter les déplacements par des tournées groupées

Le territoire n'est donc pas seulement un « désert alimentaire » : c'est un territoire où l'**accès marchand** est difficile, mais où existent des **ressources non marchandes** (jardin, conserves, entraide, savoir-faire) qui protègent une partie des ménages. Les plus vulnérables sont ceux qui cumulent l'absence de voiture, l'absence de potager et l'isolement : ce sont eux que le projet doit atteindre en priorité (universalisme proportionné).

Question 3 – Objectifs et plan d'action (5 pts)

- **Objectif général** : d'ici décembre 2027, améliorer l'accès à une alimentation diversifiée et favorable à la santé des habitants du Haut-Vallon, en valorisant les ressources du territoire.
- **Objectif spécifique 1** : d'ici décembre 2027, augmenter de 26,0 % à 35 % la part des ménages qui consomment des légumes secs au moins une fois par semaine.
- **Objectif spécifique 2** : d'ici décembre 2027, faire passer le score moyen de diversité des ménages sans potager de 6,2 à 7 au moins.
- **Objectifs opérationnels** : animer 6 ateliers intergénérationnels « légumes secs et légumes du jardin » dans trois villages entre janvier et juin 2027 (nombre d'ateliers et de participants, cible : 60 participations) ; organiser 12 tournées du minibus vers le marché et le supermarché du bourg de janvier à décembre 2027 (registre) ; mettre en place deux points de troc et de dons de légumes en juillet-septembre 2027 (nombre de dépôts) ; éditer avant novembre 2027 un livret de 30 recettes recueillies auprès des aînés (livret imprimé) ; organiser avec l'épicerie itinérante 5 dégustations de légumes secs et de produits locaux (comptage).

Action	Contenu	Notion mobilisée
1. Ateliers intergénérationnels	Une aînée ou un aîné transmet une recette, le diététicien l'adapte (temps, sel, budget)	Transmission des savoir-faire, valorisation des ressources
2. Minibus du jeudi	Tournée vers le marché et le supermarché pour les personnes sans voiture	Accès physique ; lien social
3. Trocs et dons de légumes	Étagères dans deux mairies en été, recettes « anti-gaspillage »	Saisonnalité, alimentation durable, solidarité
4. Livret « Nos recettes du Haut-Vallon »	Recettes recueillies, photos des plats, adaptations rapides	Identité du territoire, mémoire, transmission

Action	Contenu	Notion mobilisée
5. Dégustations à l'épicerie itinérante	Lentilles, pois chiches, légumes de saison ; fiches recettes	Exposition et découverte, accès
6. Ateliers « conserver sans risque »	Congélation, séchage, règles de sécurité des conserves maison	Hygiène, prévention du botulisme

Question 4 – Évaluation et budget (3 pts)

Calcul posé – Budget prévisionnel (prix construits pour le sujet)

- Denrées des ateliers : 6 ateliers × 10 portions × 2,00 € = **120,00 €**.
- Carburant du minibus : 12 tournées × 15,00 € = **180,00 €**.
- Matériel des points de troc (caisses, étagères, affichettes) : **150,00 €**.
- Livret de recettes : 200 exemplaires × 1,50 € = **300,00 €**.
- Intervention sur la conservation sûre (prestation) : **150,00 €**.
- Communication (affiches, bulletin intercommunal, mairies) : **120,00 €**.
- Dégustations : 5 × 20,00 € = **100,00 €**.
- Sous-total : 120 + 180 + 150 + 300 + 150 + 120 + 100 = **1 120,00 €**.
- Imprévus : 1 200 − 1 120 = **80,00 €**, soit 80 / 1 200 × 100 = **6,7 %**.

Total : **1 200,00 €**.

Évaluation : **processus** (nombre d'ateliers, de participants et de villages touchés ; part des participants sans voiture ou sans potager ; nombre de tournées et de passagers ; dépôts de troc ; budget) ; **résultats** (part des ménages qui consomment des légumes secs chaque semaine ; score de diversité des ménages sans potager, avec le même rappel des 24 heures, à la même saison) ; **appropriation** (recettes refaites à la maison, nombre de recettes données pour le livret, implication des acteurs du PAT).

Question 5 – Éthique et cadre juridique (3 pts)

- **Données de l'enquête** : questionnaire anonyme ; pas de collecte inutile (principe de minimisation du RGPD) ; information des répondants sur la finalité ; stockage sécurisé ; résultats présentés de façon agrégée, sans qu'un ménage d'un petit village puisse être reconnu (dans une commune de 150 habitants, un détail suffit à identifier une personne).
- **Photos** : accord écrit des personnes photographiées, droit de retrait ; pour le livret, photographier les plats et les mains ; citer les auteurs des recettes seulement s'ils le souhaitent.
- **Partenariat avec le supermarché** : la neutralité de l'action de santé publique interdit de faire la promotion d'une enseigne ; un financement est possible sous forme de mécénat discret (mention « avec le soutien de », sans logo dominant ni message commercial), avec une convention écrite ; sinon, refuser et rechercher d'autres financements (PAT, mutuelles, conférence des financeurs).
- **Respect des pratiques et des savoirs** : ne pas juger les habitudes (conserves, charcuterie, plats traditionnels) ; partir des savoir-faire des habitants ; rappeler les règles de sécurité des conserves maison sans disqualifier les pratiques.

Question 6 – Expression et sources (2 pts) : vocabulaire précis (autoproduction, accès physique et économique, score de diversité, universalisme proportionné), sources datées (loi de 2014 sur les PAT, loi EGalim de 2018, FANTA 2006 et FAO 2011 pour le HDDS).

Temps 2

Question 7 – Besoins et justification du menu (3 pts)

Besoins : retrouver des savoir-faire sur les **légumes secs** (26,0 % seulement en consomment chaque semaine), utiliser des légumes **de garde** (carottes, oignons, chou) disponibles l'hiver dans les potagers et à l'épicerie itinérante, préparer des plats rassasiants, économiques et faciles à conserver, adaptés à des personnes âgées (mastication) et à un diabète. Le menu part des pratiques du territoire : plat mijoté « comme chez nos grands-

mères », œufs d'une éleveuse locale, pommes du verger, fromage blanc ; il est **végétarien** et riche en fibres, peu coûteux, et se prépare à l'avance.

Question 8 – Bon de commande, fiche technique, apports et adaptations (5 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 10 portions

Denrée	Quantité nette	Quantité brute	Coût
Lentilles vertes sèches	600 g	600 g	0,600 × 3,20 = 1,92 €
Carottes	800 g	800 / 0,85 = 941,2 g	0,941 × 1,40 = 1,32 €
Oignons	300 g	300 / 0,90 = 333,3 g	0,333 × 1,60 = 0,53 €
Chou blanc	600 g	600 / 0,80 = 750,0 g	0,750 × 1,30 = 0,98 €
Huile de colza	50 g	50 g	0,050 × 3,20 = 0,16 €
Œufs	10	10	10 × 0,32 = 3,20 €
Pain de campagne	400 g	400 g	0,400 × 3,60 = 1,44 €
Pommes	1 300 g	1 300 / 0,90 = 1 444,4 g	1,444 × 2,20 = 3,18 €
Fromage blanc 2-3 % MG	1 000 g	1 000 g	1,000 × 2,60 = 2,60 €
Miel	80 g	80 g	0,080 × 14,00 = 1,12 €
Aromates, épices, sel, poivre	–	–	forfait 0,50 €
Total			16,95 €

Coût par portion = 16,95 / 10 = **1,70 €** (1,69 € sans arrondir chaque ligne), inférieur au plafond de 2,00 €. Les œufs (3,20 €) et les pommes (3,18 €) sont les postes les plus chers ; les lentilles ne coûtent que 0,19 € par portion.

Modèle – Fiche technique des lentilles mijotées aux légumes d'hiver, œuf poché (10 portions)

Ingrédients : lentilles vertes 600 g ; carottes 800 g nettes ; oignons 300 g nets ; chou blanc 600 g net ; huile de colza 50 g ; thym, laurier, clou de girofle ; poivre ; sel en fin de cuisson, avec modération ; œufs 10 ; vinaigre pour le pochage.

Étapes : 1) Trier et rincer les lentilles (pas de trempage pour les lentilles vertes). 2) Éplucher et tailler carottes en rondelles, oignons émincés, chou en fines lanières. 3) Faire suer les oignons dans l'huile, ajouter les carottes et le chou. 4) Ajouter les lentilles, couvrir d'eau froide (environ trois fois leur volume), ajouter thym, laurier et un oignon piqué d'un clou de girofle. 5) Cuire à frémissement 25 à 30 minutes, saler en fin de cuisson. 6) Pocher les œufs 3 minutes dans une eau frémissante vinaigrée, égoutter. 7) Servir les lentilles en assiette creuse, l'œuf posé dessus.

Points critiques : tri des lentilles (petits cailloux) ; lavage des légumes terreux ; œufs propres, non lavés, conservés au froid, cassés à part ; maintien au chaud au-dessus de 63 °C ou refroidissement rapide des restes.

Calcul posé – Apport d'une portion (poids nets crus, Ciqual 2025)

Préparation	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)
Lentilles mijotées et œuf	368,2	23,2	35,5	8,5	11,5	14,8	0,30	4,84
Pain de campagne	101,2	3,0	20,0	1,0	0,5	1,7	0,47	0,60
Pomme au four, fromage blanc au miel	172,4	7,7	25,5	24,1	3,6	1,8	0,09	0,14
Repas complet	**641,8**	**33,9**	**81,0**	**33,7**	**15,6**	**18,3**	**0,87**	**5,58**

Exemple : lentilles 60 × 327 / 100 = 196,2 kcal ; 60 × 25,1 / 100 = 15,06 g de protéines ; 60 × 16,4 / 100 = 9,84 g de fibres ; 60 × 6,3 / 100 = 3,78 mg de fer.

Répartition de l'énergie : protéines 33,9 × 4 / 641,8 = **21,1 %** ; glucides 81,0 × 4 / 641,8 = **50,5 %** ; lipides 15,6 × 9 / 641,8 = **21,9 %** ; fibres environ 5,7 %.

Commentaire : repas rassasiant, riche en protéines (33,9 g, dont une grande part d'origine végétale), très riche en **fibres** (18,3 g, soit 61 % des 30 g conseillés par jour), peu salé (0,87 g) ; le fer (5,58 mg, soit 50,7 % de la référence de 11 mg par jour de l'ANSES pour un adulte homme ou une femme ménopausée) est surtout non héminique, moins bien absorbé : un fruit riche en vitamine C au repas ou du chou cru en salade améliorent son absorption. Les sucres viennent surtout du dessert (pomme et miel).

Adaptations :

- **M. G. (diabète de type 2)** : garder les lentilles (riches en fibres, réponse glycémique modérée) ; servir le pain complet ou en quantité modérée ; dessert : pomme au four à la cannelle **sans miel**, fromage blanc nature (on retire 6,5 g de sucres) ; prendre le dessert à la fin du repas, et non à distance.
- **Mme V. (mastication)** : lentilles bien cuites, éventuellement écrasées à la fourchette ou mixées en partie avec un peu de bouillon ; chou cuit plus longtemps et finement émincé ; œuf poché (texture tendre) ; pain sans croûte ou trempé ; pomme au four bien cuite, sans peau.

Question 9 – Organisation et animation intergénérationnelle (4 pts)

Horaire	Candidat	Participants
9 h 00 – 9 h 30	Contrôle des denrées, mise en place des postes, préchauffage du four à 180 °C	–
9 h 30 – 9 h 45	Accueil ; tour de table « un plat de légumes secs de mon enfance »	Mme L. raconte la recette de sa mère
9 h 45 – 10 h 15	Démonstration du tri, de la taille des légumes et du pochage	Binômes : un aîné qui sait faire, un participant qui apprend
10 h 15 – 10 h 50	Supervision ; lancement de la cuisson des lentilles (30 min) ; pommes au four (35 min)	Taille des légumes, préparation des pommes, fromage blanc
10 h 50 – 11 h 10	Pochage des œufs ; dressage, dont l'assiette adaptée à Mme V.	Mise de la table
11 h 10 – 11 h 50	Repas partagé ; dégustation ; échange sur les variantes du potager selon la saison	Grille de dégustation
11 h 50 – 12 h 00	Évaluation ; recueil des recettes pour le livret	Remplissage de la grille
12 h 00 – 12 h 30	Remise en état, refroidissement des restes, nettoyage, tri des déchets	Volontaires

Animation : les participants sont des **transmetteurs** autant que des apprenants ; on valorise leurs gestes, leurs mots et leurs variantes ; le diététicien apporte des repères (sel, temps de cuisson, adaptation au diabète) sans corriger les savoir-faire devant le groupe.

Question 10 – Hygiène, allergènes et éco-gestes (4 pts)

Légumes du jardin : lavage soigneux (terre), épluchage, rinçage. Œufs : propres, non lavés, conservés au froid, cassés à part, mains lavées. Légumineuses cuites : refroidir rapidement, conserver au réfrigérateur 2 à 3 jours en boîte fermée, ou congeler en portions. **Conserves maison** : rappeler que les conserves de légumes peu acides (haricots, petits pois) mal stérilisées exposent au **botulisme** ; suivre les règles des autocuiseurs et stérilisateurs, jeter tout bocal bombé ou qui sent mauvais. Allergènes : œuf, gluten (pain), lait (fromage blanc) ; vérifier le céleri éventuel dans un bouillon ou un mélange d'aromates. Éco-gestes : légumes de saison et de proximité, œufs de l'éleveuse, cuisson couverte à frémissement, épluchures au compost, restes congelés, achat des lentilles en vrac.

Question 11 – Réalisation et évaluation (4 pts)

Réalisation : lentilles tendres et non éclatées, légumes fondants, assaisonnement mesuré ; œufs pochés au blanc pris et au jaune coulant ; pommes cuites et dorées ; dressage soigné. Évaluation : grille de dégustation ; nombre de participants qui ont réalisé une étape seuls ; nombre de recettes recueillies ; question « Pensez-vous refaire ce plat dans le mois ? » ; à l'atelier suivant, « L'avez-vous refait ? Avec quels légumes ? ».

Barème – Barème du sujet mixte

Temps 1 : indicateurs, score de diversité et limites 4 ; analyse 3 ; objectifs et plan d'action 5 ; évaluation et budget 3 ; éthique 3 ; expression et sources 2 ; total 20.

Temps 2 : besoins et menu 3 ; bon de commande, fiche technique, apports et adaptations 5 ; organisation et animation 4 ; hygiène et éco-gestes 4 ; réalisation et évaluation 4 ; total 20.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

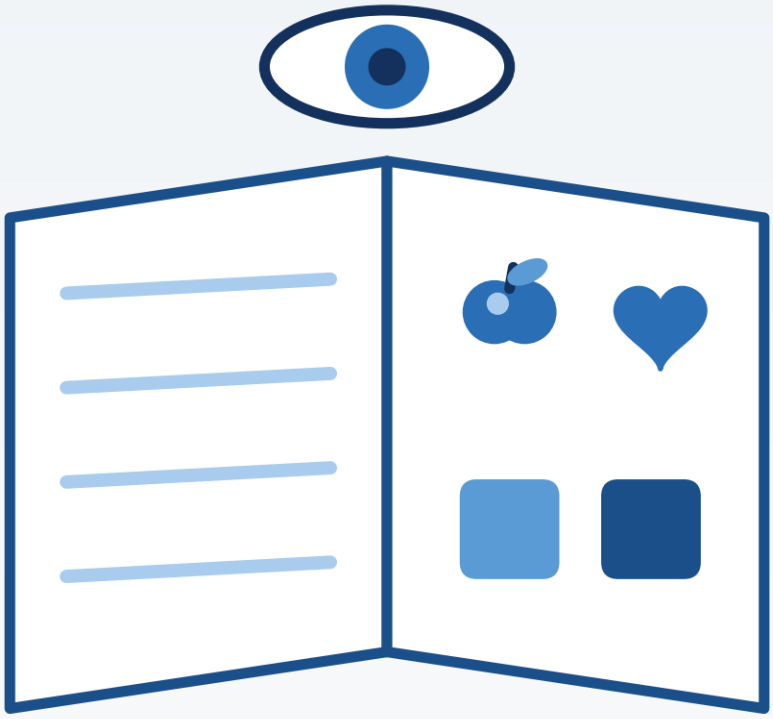
Décrire le territoire seulement par ses manques ; conclure que le potager « cause » une meilleure diversité ; oublier le très faible taux de réponse ; calculer les apports des lentilles avec le poids cuit alors que le tableau donne la lentille sèche ; oublier les pertes du chou et des carottes ; accepter un logo commercial dominant ; corriger les savoir-faire des aînés devant le groupe ; oublier le risque de botulisme des conserves maison.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Ce que je sais faire	Sujet	Acquis	En cours	À retravailler
C3.1	Calculer et interpréter des indicateurs de pratiques alimentaires (questionnaire, carnets, suivi du poids)	S1, S3			
C3.1	Analyser la structure des prises et les rythmes imposés ; calculer une durée de jeûne	S1			
C3.1	Analyser des pratiques avec les rôles de l'acte alimentaire, la régulation et les déterminants	S1, S2, S3			
C3.1	Calculer et interpréter un score de diversité alimentaire (HDDS)	S3			
C3.1	Formuler des objectifs avec indicateur, cible et échéance ; construire un budget	S1, S3			
C3.2	Établir un bon de commande avec quantités brutes et nettes ; comparer avec le coût d'un repas habituel	S2, S3			
C3.2	Calculer des apports avec la table Ciqual 2025 et comparer un repas maison à un repas de produits prêts	S2, S3			
C3.2	Classer des aliments selon NOVA et discuter les limites de la classification	S2			
C3.2	Adapter une recette (allergie à l'œuf, halal, jeune enfant, diabète, mastication)	S2, S3			
C3.2	Animer un atelier en binômes ou intergénérationnel qui valorise les savoir-faire	S2, S3			
C3.2	Appliquer l'hygiène (volaille, œufs, congélation, légumineuses cuites, conserves maison)	S2, S3			
C3.3	Calculer un risque relatif et son intervalle de confiance ; discuter la causalité	S1			
C3.3	Calculer un intervalle de confiance et une taille d'échantillon corrigée	S1			
C3.4	Organiser une veille sur un milieu spécifique (milieu pénitentiaire, territoires ruraux)	S1			
C3.5	Adapter les supports (lecture, langues, absence d'internet, personnes âgées)	S1, S3			
C3.6	Respecter le secret médical, la finalité des données, le droit à l'image ; encadrer un partenariat privé	S1, S3			

Modèles officiels utilisés : structure des sujets U62 (2002-2014) et E5.B (2021-2024) pour le bon de commande, la fiche technique et l'organisation ; BTS blanc CNED E5B pour l'adaptation d'une recette et le calcul nutritionnel ; texte de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024) pour la répartition des compétences entre les deux temps.

DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE



CHAPITRE 5

Littératie en santé

Mots-clés : Littératie en santé, Repérer, Adapter, Vérifier la compréhension

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 5 · Littératie en santé · version normale

1 COURS

Mise en page normale · 94 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 97

2 FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 7 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 98 à 104

3 CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 123 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 105 à 227

4 ANNALES E5

Mise en page normale · 33 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 228 à 260

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 • Cours **4**

5.1 Compétences mobilisées 6
5.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6
5.3 Cours 8
5.4 Approfondissements 69
5.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 78
5.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 79
5.7 L'essentiel à retenir 84
5.8 Entraînement 85
5.9 Glossaire 95
5.10 Renvois bibliographiques par notion 96
5.12 Bibliographie numérotée 96

2 • Fiche de révision et fiches-outils **98**

Fiche de révision du chapitre 5 100
1. Les définitions à savoir 100
2. Chiffres-clés 101
3. La formule à connaître 101
4. Les règles d'écriture claire 101
5. Faire dire 101
6. Les pièges 101
7. Auto-test 101
8. Flashcards 101
Compléments du chapitre enrichi 102
Fiches-outils du chapitre 5 102
O5.1 – Grille de vérification d'un support écrit 102
O5.2 – Calcul de l'indice de lisibilité 103
O5.3 – Audit « littératie » d'une structure 103
O5.4 – Guide du faire dire 103
O5.5 – Test d'un support auprès du public 104

3 • Cahier d'exercices **105**

Cahier d'exercices – Chapitre 5 108
Partie 1 – Définir la littératie en santé et la littératie alimentaire 110
Partie 2 – Les données françaises et les enjeux pour la santé publique 126
Partie 3 – Repérer sans stigmatiser et adapter le diagnostic 140
Partie 4 – Écrire clair, FALC et mesure de la lisibilité 153
Partie 5 – Vérifier la compréhension et animer un atelier accessible 168
Partie 6 – Lire une étiquette et comprendre les chiffres : littératie alimentaire et numératie 181
Partie 7 – Numérique, langues et handicaps : rendre l'information accessible 196
Partie 8 – Outils pédagogiques, littératie dans le projet et cas complet 212
Bilan : grille d'auto-évaluation 227

4 • Annales E5 ..... **228**

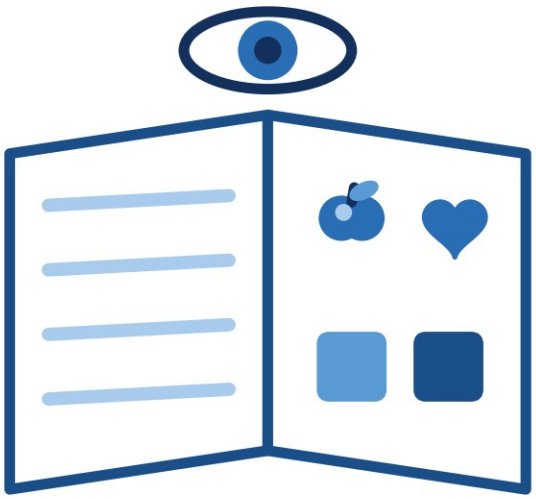
Cahier d'annales E5 – chapitre 5 230
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 231
Partie II – Les corrigés détaillés 242
Grille d'auto-évaluation 260

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS



CHAPITRE

05

Littératie en santé

Littératie en santé | Repérer | Adapter | Vérifier la compréhension

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

5.1 Compétences mobilisées 6
5.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6
5.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 7
5.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 7
5.3 Cours 8
5.3.1 Définir la littératie en santé 8
5.3.2 Les données en France 15
5.3.3 Pourquoi la littératie compte en santé publique 19
5.3.4 Repérer sans stigmatiser 22
5.3.5 Adapter les messages et les supports 26
5.3.6 Vérifier la compréhension : le « faire dire » 35
5.3.7 Intégrer la littératie à chaque étape du projet 38
5.3.8 Lire une étiquette : un savoir-faire de littératie alimentaire 40
5.3.9 Comprendre et présenter des chiffres : la numératie en santé 45
5.3.10 La littératie numérique et l'inclusion numérique en pratique 50
5.3.11 Communiquer avec des personnes allophones 54
5.3.12 Concevoir et tester un support accessible : un exemple complet 58
5.3.13 Choisir et concevoir des outils pédagogiques accessibles 60
5.3.14 Animer un atelier accessible : une séquence type 62
5.3.15 Fil rouge : la littératie au centre social des Tilleuls 64
5.3.16 Six cas guidés pour s'entraîner à intégrer la littératie 65
5.4 Approfondissements 69
5.4.1 La littératie numérique en santé (e-santé) 69
5.4.2 La médiation en santé et l'interprétariat 70
5.4.3 Les organisations « amies de la littératie » 72
5.4.4 La littératie en santé des professionnels et des organisations 73
5.4.5 L'intelligence artificielle et la simplification des textes 75
5.4.6 Développer la littératie alimentaire des enfants à l'école 76
5.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 78
5.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 79
Méthode 1 – Justifier à l'oral E5 la prise en compte de la littératie dans un projet 80
Méthode 2 – Analyser un support dans une question écrite de l'épreuve 81
Méthode 3 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve 82
Méthode 4 – Relier la littératie aux autres chapitres du cours 83
5.7 L'essentiel à retenir 84
5.8 Entraînement 85
5.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 85
5.8.2 Exercices 86
5.8.3 Questions de réflexion 90
5.8.4 Étude de cas 91
5.8.5 Mises en situation express 91
5.8.6 Exercices complémentaires 94
5.9 Glossaire 95
5.10 Renvois bibliographiques par notion 96
5.12 Bibliographie numérotée 96

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- définir la littératie en santé et la littératie alimentaire, et en décrire les dimensions (accéder, comprendre, évaluer, appliquer) et les niveaux (fonctionnel, interactif, critique) ;
- présenter les données françaises disponibles (enquête HLS19, illettrisme, illectronisme) et les relier aux inégalités sociales de santé (chapitre 2) ;
- expliquer les conséquences d'un faible niveau de littératie sur la santé et sur l'efficacité des actions de prévention ;
- repérer, sans stigmatiser, les difficultés de littératie d'un public (approche des « précautions universelles ») ;
- adapter un message écrit, oral ou numérique au niveau de littératie du public (guide « Communiquer pour tous », facile à lire et à comprendre – FALC –, pictogrammes, lisibilité) ;
- vérifier la compréhension par la technique du « faire dire » (teach-back) ;
- intégrer la littératie dans la conception, l'animation et l'évaluation d'un projet de santé publique.

5.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.1	Prendre en compte la littératie dans le diagnostic et dans chaque étape du projet	Analyse et diagnostic de situation posé ; démarche d'évaluation construite
C3.2	Rendre les ateliers culinaires accessibles (recettes en images, quantités concrètes, démonstration)	Besoins et spécificités du public identifiés ; méthodes d'animation et outils pédagogiques appropriés
C3.5	Cœur du chapitre : adapter les supports écrits, oraux et numériques, repérer la précarité numérique, vérifier la compréhension	Précarité numérique repérée et prise en compte ; supports et contenus adaptés au public ; écoute active mobilisée ; posture adaptée

5.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Littératie en santé : définitions, dimensions	Définir ; citer les 4 compétences et les 3 domaines	Modèle de Sørensen ; niveaux de Nutbeam
Données épidémiologiques	Connaître les ordres de grandeur en France	Données datées et sourcées (HLS19, ANLCI, Insee)
Littératie et inégalités sociales de santé	Expliquer le lien avec le gradient social	Lien avec le chapitre 2 et l'universalisme proportionné
Repérage des difficultés	Identifier des signaux sans stigmatiser	Pas d'évaluation « scolaire » du public ; précautions universelles
Adaptation des messages et des supports	Appliquer les règles de communication accessible	« Communiquer pour tous » (Santé publique France), FALC, pictogrammes
Vérification de la compréhension	Utiliser le « faire dire »	Posture : c'est le professionnel qui vérifie sa propre clarté

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Littératie numérique et alimentaire	Prendre en compte l'illectronisme ; développer les compétences alimentaires	Lien avec les chapitres 4, 14 et 15 (communication)

5.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : bloc 3, savoirs « Littératie en santé ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 61 pour les notions, p. 24 et 25 pour le lien avec le bloc 1, p. 122 pour les ressources). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 5.2.2.

Texte	Critère ou indication	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 61	Définition de la littératie en santé	5.3.1 (définitions datées, modèles de Sørensen et de Nutbeam)
Guide 2025, p. 61	Déterminants de la littératie en santé	5.3.2 (gradient social, données HLS19, PIAAC, Insee, DEPP) ; 5.3.3
Guide 2025, p. 61	Concept et enjeux	5.3.3 (conséquences pour la santé, inégalités) ; 5.4.3 et 5.4.4 (organisations)
Guide 2025, p. 61	Freins et leviers pour augmenter le niveau de littératie	5.3.4 à 5.3.14 (repérer, adapter, faire dire, numératie, numérique, allophones, outils)
Guide 2025, p. 24-25	Améliorer la littératie des personnes prises en soin (lien avec le bloc 1) ; littératie numérique	5.3.6 ; 5.3.10 ; 5.4.1
Guide 2025, p. 122	Ressources : « Communiquer pour tous » (mise à jour 2025), avis de la CNS (2017), Van den Broucke (2017), Le Brun et coll. (2025)	5.3.5 ; 5.12 (références 10, 25 à 27)
Référentiel, C3.1, C3.2, C3.5	Publics, supports adaptés, communication accessible	5.3.12 à 5.3.15 ; 5.6

5.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Aucun des fascicules du CNED disponibles (*Environnement professionnel – Les essentiels*, 2e année ; *Synthèse du cours en bref*, 1re année ; fascicules d'hygiène et d'atelier) ne traite la littératie en santé : la notion est récente dans le référentiel de 2024. Le chapitre s'appuie donc sur le guide de 2025 et sur ses ressources. Les passages du CNED qui s'en rapprochent sont reliés au cours ci-dessous.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Essentiels M1 S1 §4 (p. 5 et 6)	Éducation pour la santé, promotion de la santé, éducation thérapeutique	5.3.1 (niveaux de Nutbeam et éducation pour la santé) ; chapitre 1
Synthèse 1re année M3 S1 §2 (p. 29)	Information nutritionnelle : étiquetage et Nutri-Score	5.3.8 (lire une étiquette)
Synthèse 1re année M2 S2 §6 (p. 18)	Précarité et pauvreté	5.3.3 (littératie et inégalités sociales de santé) ; chapitre 4

Attention – données mises à jour – Ce qui a changé depuis les premières versions du cours

- **Illectronisme** : le chiffre de 15,4 % des 15 ans ou plus (2021) est remplacé par la dernière enquête de l'Insee : en 2025, **7 %** des 16-74 ans sont en situation d'illectronisme (10 % en 2021) et **34 %** ont des

difficultés numériques (publication du 19 février 2026). Attention, la tranche d'âge n'est plus la même.

- **Compétences des adultes** : les résultats de PIAAC 2023 sont maintenant chiffrés : **28 %** des 16-65 ans ont une faible maîtrise de l'écrit et 27 % du calcul (Dares, décembre 2024).
- **Lecture des jeunes** : à la Journée défense et citoyenneté 2025, **14 %** des jeunes sont en difficulté de lecture, dont 6 % en très grande difficulté (DEPP, octobre 2026).
- **Illettrisme** : le chiffre de 7 % des 18-65 ans (enquête IVQ 2011) reste la dernière mesure nationale publiée.
- **HLS19** : les résultats de 2021 restent les derniers pour la France ; le cycle HLS24 recueille ses données jusqu'en juin 2026.
- **Nutri-Score** : l'algorithme révisé s'applique en France depuis l'arrêté du 14 mars 2025, et non « depuis 2024 ».
- **« Communiquer pour tous »** : le guide de 2018 a été mis à jour en février 2025.

5.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

5.3.1 Définir la littératie en santé

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Essentiels M1 S1 §4 (p. 5 et 6)

Des définitions qui se sont élargies

Le mot **littératie** (de l'anglais *literacy*) désigne d'abord la capacité à lire, écrire et compter pour fonctionner dans la vie quotidienne. Appliquée à la santé, la notion s'est élargie : il ne s'agit plus seulement de savoir lire une notice, mais de **trouver**, **comprendre**, **juger** et **utiliser** les informations pour prendre des décisions favorables à sa santé, dans les soins comme dans la vie de tous les jours.

Définition – Littératie en santé (Sørensen et coll., 2012)

« La littératie en santé est liée à la littératie et englobe les **connaissances**, la **motivation** et les **compétences** permettant d'**accéder**, de **comprendre**, d'**évaluer** et d'**appliquer** l'information en santé, afin de porter des jugements et de prendre des décisions dans la vie quotidienne en matière de **soins**, de **prévention** des maladies et de **promotion de la santé**, pour maintenir ou améliorer la qualité de vie tout au long de la vie. » Cette définition, issue d'une revue de 17 définitions et 12 modèles, est la plus utilisée en Europe (consortium HLS-EU).

Définition – Littératie en santé organisationnelle

Capacité d'une **organisation** (hôpital, centre social, service de restauration, site internet) à rendre l'information et les services **faciles à trouver, à comprendre et à utiliser** pour tous. Elle déplace la responsabilité : la littératie n'est pas seulement une compétence de la personne, c'est aussi une **qualité de l'environnement** (signalétique, documents, accueil, démarches en ligne).

Attention – La littératie n'est pas l'intelligence ni le niveau d'études

Une personne très diplômée peut avoir une littératie en santé limitée dans une situation stressante (annonce d'un diagnostic, langue étrangère, fatigue, deuil) ou dans un domaine nouveau (lire un tableau nutritionnel). La littératie dépend de la **personne**, de la **situation** et de la **complexité de l'information**. On parle donc de **situations de littératie limitée** plutôt que de « personnes illettrées en santé ».

Les 12 dimensions du modèle de Sørensen

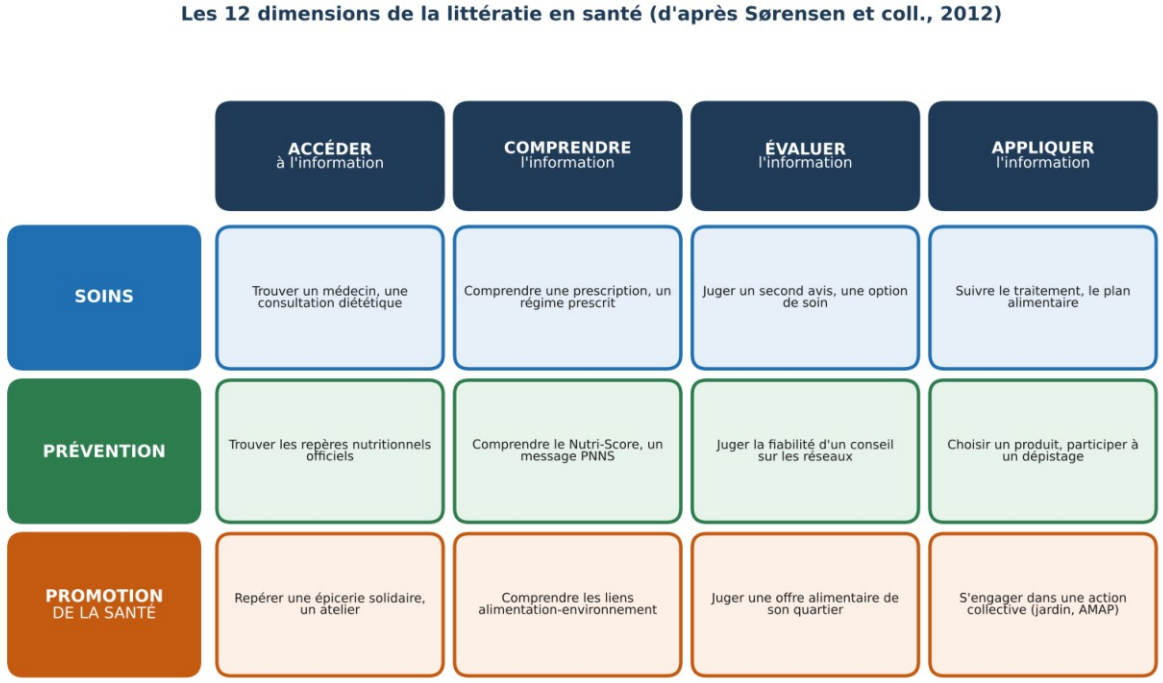


Figure 5.1 – Les 12 dimensions de la littératie en santé

Comprendre le schéma – Figure 5.1

1. Les **colonnes** représentent les quatre **compétences** de traitement de l'information : **accéder** (rechercher, trouver, obtenir), **comprendre**, **évaluer** (interpréter, juger, filtrer) et **appliquer** (communiquer, décider, agir).
2. Les **lignes** représentent les trois **domaines** de la santé : **soins** (être malade, patient), **prévention** (être à risque), **promotion de la santé** (être citoyen dans son milieu de vie).
3. Le croisement donne **12 dimensions** ; l'enquête européenne HLS-EU les mesure par 47 questions du type : « Sur une échelle de très facile à très difficile, à quel point est-il facile pour vous de… comprendre les informations sur les emballages des aliments ? »
4. Exemples alimentaires : *accéder* aux repères du PNNS sur *mangerbouger.fr* ; *comprendre* le Nutri-Score ; *évaluer* un conseil de régime lu sur un réseau social ; *appliquer* en choisissant un produit au magasin.
5. Intérêt pour le diététicien : ce modèle sert de **grille** pour diagnostiquer les besoins d'un public (à quelle étape la difficulté se situe-t-elle ?) et pour construire des objectifs pédagogiques précis.

Les trois niveaux de Nutbeam

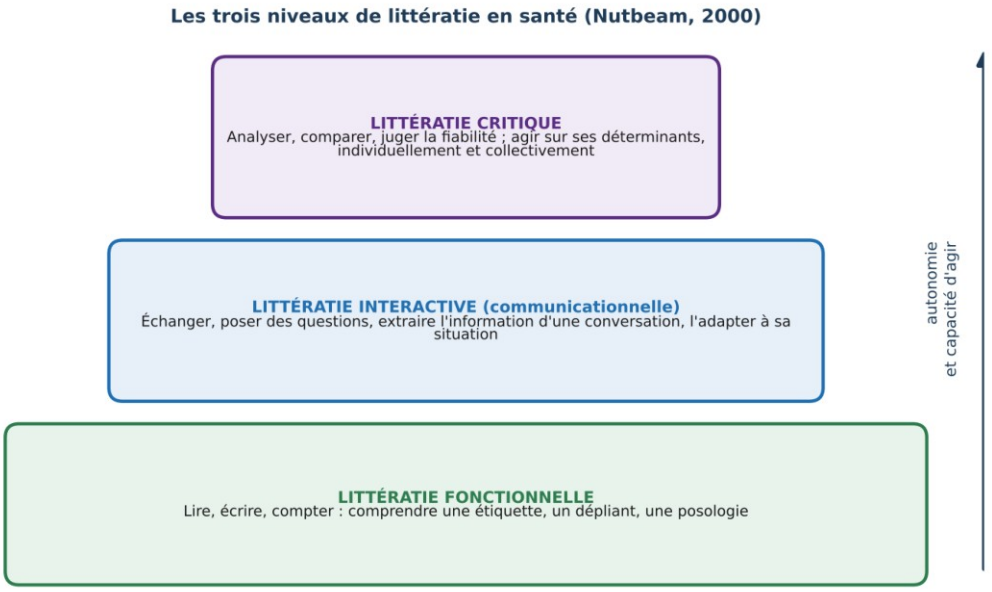


Figure 5.2 – Les trois niveaux de littératie en santé

Comprendre le schéma – Figure 5.2

1. Littératie fonctionnelle : compétences de base en lecture, écriture et calcul permettant de comprendre une information simple (une étiquette, une date limite de consommation, un dépliant). L'information « descend » vers la personne.

2. Littératie interactive ou communicationnelle : compétences cognitives et sociales permettant d'**échanger** (poser des questions au médecin, au diététicien), d'extraire l'information d'une conversation et de l'adapter à sa situation.

3. Littératie critique : capacité à **analyser** les informations, à en juger la fiabilité (publicité, réseaux sociaux, « fausses informations ») et à agir sur les **déterminants** de sa santé, individuellement et collectivement (association de parents qui obtient une meilleure offre à la cantine).

4. Plus on monte, plus la personne gagne en **autonomie** et en **pouvoir d'agir** (*empowerment*, chapitre 3). L'éducation pour la santé vise les trois niveaux ; la promotion de la santé (Charte d'Ottawa) vise particulièrement le niveau critique.

La littératie alimentaire

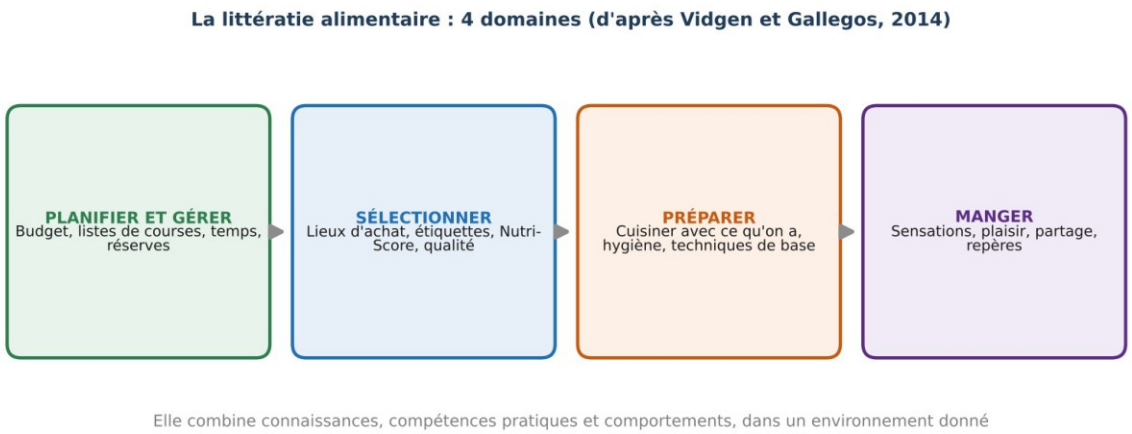


Figure 5.3 – Les quatre domaines de la littératie alimentaire

Définition – Littératie alimentaire (food literacy)

Ensemble de **connaissances**, de **compétences** et de **comportements** interreliés, nécessaires pour **planifier, gérer, sélectionner, préparer et manger** des aliments afin de répondre à ses besoins et d'en déterminer les apports (Vidgen et Gallegos, 2014, qui décrivent 4 domaines et 11 composantes).

Comprendre le schéma – Figure 5.3

1. Planifier et gérer : prévoir les repas, faire une liste, gérer un budget et des réserves, organiser son temps.

2. Sélectionner : savoir où acheter, lire une étiquette (liste d'ingrédients, Nutri-Score, dates), juger la qualité et la fraîcheur.

3. Préparer : cuisiner avec ce que l'on a, appliquer les règles d'hygiène, maîtriser des techniques de base (cuire des légumes secs, faire une soupe).

4. Manger : écouter ses sensations, partager, connaître les repères de consommation.

5. Lien avec le BC3 : un atelier culinaire en centre social développe directement la littératie alimentaire ; elle est un **objectif** à part entière, que l'on peut évaluer (« sait lire une étiquette », « sait cuisiner les lentilles »).

D'où vient la notion : quatre définitions datées

L'expression *health literacy* apparaît en 1974 dans un article de Scott Simonds sur l'éducation pour la santé à l'école : il proposait déjà de fixer des niveaux minimaux de connaissances en santé à atteindre, comme on le fait pour la lecture ou le calcul. La notion se développe ensuite dans les années 1990, d'abord aux États-Unis dans le monde du soin, puis en Europe dans celui de la promotion de la santé. Les définitions successives montrent comment elle s'est élargie.

Année	Auteur ou institution	Ce que la définition met en avant
1998	Nutbeam, glossaire de la promotion de la santé de l'OMS	Les compétences cognitives et sociales qui déterminent la motivation et la capacité des personnes à accéder à l'information, à la comprendre et à l'utiliser pour maintenir une bonne santé
2004	Institute of Medicine (États-Unis), rapport *Health Literacy: A Prescription to End Confusion*	La capacité à obtenir, traiter et comprendre l'information et les services de santé de base nécessaires pour prendre des décisions appropriées

Année	Auteur ou institution	Ce que la définition met en avant
2012	Sørensen et coll., consortium HLS-EU	Connaissances, motivation et compétences ; quatre compétences et trois domaines (définition du cours)
2021	Glossaire de la promotion de la santé de l'OMS (mise à jour)	Les connaissances et compétences personnelles qui s'acquièrent par les activités quotidiennes, les interactions sociales et les générations, et qui sont soutenues par les organisations et les ressources disponibles

La dernière définition ajoute deux idées importantes : la littératie s'apprend aussi dans la vie de tous les jours et dans la famille, et elle dépend des **organisations** qui rendent l'information accessible ou non.

Définition – Ne pas confondre trois notions voisines

- **Alphabétisation** : apprentissage de la lecture et de l'écriture par des adultes qui ne les ont jamais apprises.
- **Éducation pour la santé** : action organisée qui aide les personnes à acquérir des connaissances et des compétences pour leur santé (chapitre 1). C'est un **moyen** ; la littératie en est l'un des **résultats**.
- **Littératie en santé** : ce que la personne sait faire avec l'information de santé, dans une situation donnée, compte tenu de l'information qu'on lui donne.

Lien diététique – Ce que cette évolution change pour le diététicien

Avec les premières définitions, on cherchait surtout à repérer les patients qui comprenaient mal. Avec les définitions récentes, on se demande aussi : mes supports, mon accueil et mes démarches sont-ils faciles à comprendre ? Le diététicien agit donc à deux niveaux : il développe les compétences du public (ateliers, éducation) et il simplifie ce que sa structure produit (menus, fiches, inscriptions).

À vous de jouer – Exercice d'application 5.1

Classez les trois actions suivantes selon qu'elles développent les compétences des personnes ou qu'elles rendent l'organisation plus accessible : a) un atelier où les participants comparent des étiquettes ; b) la réécriture du règlement de la cantine avec des pictogrammes ; c) un groupe de parents qui apprend à préparer une question pour la réunion avec la mairie.

Corrigé

a) Compétences des personnes (littératie fonctionnelle et critique). b) Organisation plus accessible (littératie organisationnelle). c) Compétences des personnes, au niveau interactif et critique : le groupe apprend à échanger et à agir sur un déterminant.

La littératie distribuée : on ne comprend pas toujours seul

Dans la vie réelle, beaucoup de personnes ne traitent pas seules l'information de santé. Un enfant lit le courrier à ses parents, une voisine explique l'ordonnance, un collègue montre l'application de la mutuelle. Edwards et coll. (2015) ont appelé ce phénomène la **littératie en santé distribuée** : les compétences utiles sont réparties entre la personne et son entourage, qui joue le rôle de **médiateur**.

Définition – Littératie en santé distribuée

Ensemble des compétences de littératie mobilisées par une personne **et** par les membres de son réseau (famille, amis, voisins, aidants) pour trouver, comprendre, juger et utiliser une information de santé. La littératie d'un foyer n'est donc pas celle de son membre le moins à l'aise.

Atout	Risque	Ce que fait le professionnel
L'entourage aide à comprendre et à agir	Le médiateur peut se tromper ou déformer le message	Vérifier ce qui a été compris par la personne elle-même (faire dire)
L'aide est disponible au quotidien, dans la langue de la famille	La personne perd son autonomie et ses choix	S'adresser d'abord à la personne, demander son accord pour associer un proche
Le groupe d'entraide crée de la confiance	Un enfant porte une responsabilité qui n'est pas la sienne	Ne pas utiliser un enfant comme interprète ; proposer un adulte relais ou un interprète professionnel
Le proche aidant connaît les habitudes	Le secret des informations personnelles n'est plus garanti	Demander à la personne ce qu'elle accepte de partager

Exemple – Un atelier qui s'appuie sur l'entourage

Dans une résidence pour personnes âgées, une diététicienne invite chaque résident à venir à l'atelier « petit-déjeuner » avec la personne qui fait ses courses (enfant, aide à domicile, voisin). Les deux repartent avec la même liste de courses en images. Trois semaines plus tard, elle demande au résident, puis à l'accompagnant, ce qui a changé. L'atelier développe ainsi la littératie du « binôme » sans retirer au résident ses choix.

La littératie en santé mentale

La notion a été étendue à d'autres domaines. Jorm et coll. (1997) ont défini la **littératie en santé mentale** comme les connaissances et les croyances sur les troubles psychiques qui aident à les reconnaître, à les prendre en charge ou à les prévenir. Pour le diététicien, elle concerne en particulier les troubles des conduites alimentaires (chapitre 4) : savoir reconnaître les signes, savoir à qui s'adresser, et ne pas croire que « c'est un caprice ».

À vous de jouer – Exercice d'application 5.2

Un père vient à un atelier avec sa fille de 11 ans, qui traduit tout ce que dit l'animatrice. Citez un atout et deux risques de cette situation, puis proposez une solution pour la séance suivante.

Corrigé

Atout : le père peut participer et la fille apprend aussi. Risques : la fille peut mal traduire des mots techniques ; elle porte une responsabilité d'adulte et entend des informations qui ne la concernent pas (par exemple sur la santé de son père). Solution : demander au père dans quelle langue il est à l'aise et prévoir une médiatrice ou un interprète pour les consignes importantes ; s'appuyer sur la démonstration et les images ; laisser la fille participer à l'atelier comme enfant, sans rôle de traductrice.

Les onze composantes de la littératie alimentaire

Vidgen et Gallegos (2014) ont construit leur définition à partir d'entretiens avec des experts et avec de jeunes adultes de milieux défavorisés en Australie. Ils décrivent, dans les quatre domaines, **onze composantes** qui sont autant d'objectifs possibles pour un atelier. Le tableau en donne une version simplifiée en français.

Domaine	Composante (d'après Vidgen et Gallegos, 2014)	Exemple d'objectif d'atelier
Planifier et gérer	1. Donner une place à l'alimentation dans son budget et son temps	Savoir prévoir un budget alimentaire pour la semaine
	2. Prévoir ses repas et ses achats	Savoir écrire ou dessiner une liste de courses pour 5 repas

Domaine	Composante (d'après Vidgen et Gallegos, 2014)	Exemple d'objectif d'atelier
	3. Faire des choix réalistes qui tiennent compte de ses besoins et de ses contraintes	Savoir adapter un menu quand l'argent manque en fin de mois
Sélectionner	4. Connaître les lieux où se procurer des aliments et leurs avantages	Savoir comparer le marché, le supermarché et l'épicerie solidaire
	5. Savoir ce que contient un aliment, d'où il vient, comment le conserver et l'utiliser	Savoir lire une liste d'ingrédients et une date
	6. Juger la qualité d'un aliment	Savoir choisir des fruits mûrs et repérer un emballage abîmé
Préparer	7. Faire un plat bon avec les aliments disponibles et le matériel de la maison	Savoir cuisiner un plat complet avec une seule plaque
	8. Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité	Savoir refroidir et conserver un reste
Manger	9. Comprendre le lien entre l'alimentation et le bien-être	Savoir dire pourquoi un petit-déjeuner aide un enfant à l'école
	10. Ajuster ses consommations à ses besoins	Savoir reconnaître sa faim et choisir une portion
	11. Partager les repas et manger avec les autres	Savoir organiser un repas partagé

Attention – Littératie alimentaire et pauvreté

La littératie alimentaire ne suffit pas quand l'argent, le temps ou l'équipement manquent. Une personne peut savoir cuisiner les lentilles mais ne pas avoir de cuisine dans un hôtel social. Le diététicien évite donc de présenter le manque de compétences comme la cause principale d'une alimentation déséquilibrée : il agit aussi sur l'accès aux aliments et sur l'environnement (chapitre 2).

Lien diététique – Ce que l'on sait de l'effet des ateliers cuisine

Les revues de la littérature sur les interventions de cuisine chez l'adulte (par exemple Reicks et coll., 2014) rapportent des effets favorables sur la confiance en cuisine, les attitudes et certains comportements alimentaires, mais les études sont souvent courtes, sans groupe témoin et sur de petits effectifs. Il faut donc évaluer ses propres ateliers (chapitre 9) et ne pas promettre des résultats que l'on ne mesurera pas.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.3

Un centre social prévoit trois ateliers : « cuisiner les restes », « faire ses courses avec 30 € », « le goûter des enfants ». Pour chacun, indiquez le domaine de la littératie alimentaire principal et une composante du tableau.

Corrigé

« Cuisiner les restes » : préparer, composantes 7 (faire un plat avec ce que l'on a) et 8 (conserver un reste en sécurité). « Faire ses courses avec 30 € » : planifier et gérer, composantes 1 à 3, et sélectionner, composante 4. « Le goûter des enfants » : manger, composantes 9 et 10, et planifier, composante 2.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.1 – Définir la littératie

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre compétences et les trois domaines de la définition de Sørensen et coll. (2012).

2. Nommez les trois niveaux de Nutbeam et donnez un exemple alimentaire du niveau critique.
3. Qu'ajoute la définition de l'OMS de 2021 par rapport aux premières définitions ?
4. Définissez la littératie en santé distribuée.
5. Citez les quatre domaines de la littératie alimentaire.
6. Pourquoi parle-t-on de « situations de littératie limitée » ?

Corrigé – Point d'étape 5.3.1

1. Accéder, comprendre, évaluer, appliquer ; soins, prévention, promotion de la santé.
2. Fonctionnel, interactif, critique ; par exemple un groupe d'habitants qui obtient un marché de fruits et légumes à prix solidaires dans le quartier.
3. La littératie s'acquiert aussi dans la vie quotidienne et dans la famille, et elle dépend des organisations et des ressources disponibles.
4. Les compétences de la personne et de son entourage (famille, voisins, aidants) mobilisées ensemble pour utiliser une information de santé.
5. Planifier et gérer, sélectionner, préparer, manger.
6. Parce que la littératie varie selon la personne, la situation (stress, langue, fatigue) et la complexité de l'information.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

5.3.2 Les données en France

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

L'enquête HLS19

L'enquête **HLS19** (*Health Literacy Survey 2019-2021*) a été conduite dans 17 pays européens par le réseau **M-POHL** de l'OMS Europe, avec un questionnaire commun. En France, elle a porté sur un échantillon représentatif d'adultes ; les résultats ont été publiés en 2021.

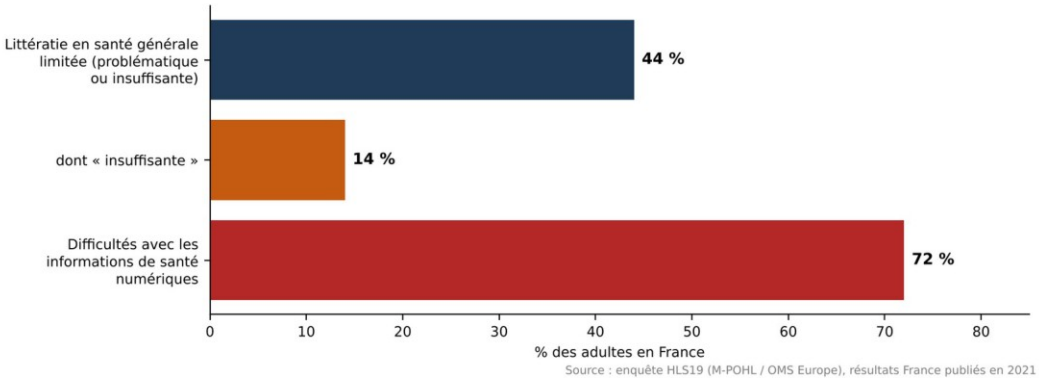


Figure 5.4 – La littératie en santé des adultes en France (HLS19)

Comprendre le schéma – Figure 5.4

1. Environ **44 %** des adultes ont une littératie en santé générale **limitée** : « problématique » (environ 30 %) ou « insuffisante » (environ 14 %) ; autrement dit, plus de **4 adultes sur 10** déclarent des difficultés à trouver, comprendre, juger ou utiliser les informations de santé.

2. Les difficultés sont encore plus fréquentes pour les informations **numériques** (environ 72 % déclarent au moins des difficultés), ce qui interroge les campagnes « tout en ligne ».
3. Comme ailleurs en Europe, le niveau suit un **gradient social** : il est plus bas chez les personnes ayant des difficultés financières, un faible niveau d'études, chez les plus âgés et chez les personnes en mauvaise santé.
4. Les tâches jugées les plus difficiles concernent l'**évaluation** (juger la fiabilité d'une information dans les médias, savoir si un conseil s'applique à soi).
5. Prudence : ces données sont **déclaratives** (difficulté ressentie) ; elles se comparent dans le temps et entre pays parce que l'instrument est commun.

Illettrisme et illectronisme

Indicateur	Donnée	Source
Illettrisme	7 % des 18-65 ans ayant été scolarisés en France, soit environ 2,5 millions de personnes ; plus de la moitié sont en emploi	ANLCI, enquête Information et vie quotidienne (Insee), 2011
Compétences des adultes	En 2023, 28 % des 16-65 ans ont une faible maîtrise de l'écrit et 27 % du calcul ; scores de la France (255 en littératie, 257 en numératie) inférieurs à la moyenne de l'OCDE (261 et 264)	OCDE, PIAAC 2e cycle ; Dares Analyses n° 73, décembre 2024
Illectronisme	En 2025, 7 % des 16-74 ans n'utilisent pas internet ou n'ont aucune compétence numérique (10 % en 2021) ; 34 % sont en difficulté numérique, illectronisme ou compétences faibles	Insee, enquête TIC ménages 2025, publiée le 19 février 2026
Langue	Une part des publics des quartiers prioritaires maîtrise peu le français écrit (primo-arrivants)	Diagnostics locaux, structures d'apprentissage du français

Définition – Illettrisme, analphabétisme, français langue étrangère (FLE)

- **Illettrisme** : situation de personnes qui ont été **scolarisées en France** mais n'ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l'écriture et du calcul pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante (définition de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, ANLCI).
- **Analphabétisme** : personnes qui n'ont **jamais été scolarisées** et n'ont pas appris à lire et à écrire.
- **Français langue étrangère** : personnes scolarisées dans une autre langue, qui apprennent le français ; elles peuvent avoir une bonne littératie dans leur langue.
- **Illectronisme** : difficulté ou incapacité à utiliser les outils numériques et internet, par manque d'équipement ou de compétences.

Attention – Les chiffres ne se résument pas

L'illettrisme (7 %), l'illectronisme (7 % des 16-74 ans), les difficultés numériques (34 %) et la littératie en santé limitée (44 %) mesurent des choses **différentes** : on ne les additionne pas. Une personne peut lire parfaitement et avoir du mal à juger une information de santé ; une autre peut lire difficilement mais très bien échanger avec un professionnel.

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **HLS19** : dernières données françaises publiées (2021) ; le cycle suivant, **HLS24**, auquel participe la France, recueille ses données de juillet 2024 à juin 2026 ; son rapport international n'était pas publié au 26

octobre 2026.

- **PIAAC 2023** : résultats publiés en décembre 2024 ; en France, 28 % des 16-65 ans ont une faible maîtrise de l'écrit (Dares, 2024).
- **Illectronisme** : dernière enquête TIC ménages de l'Insee (2025, publiée le 19 février 2026) : 7 % des 16-74 ans.
- **Communiquer pour tous** : guide de Santé publique France (mai 2018, mis à jour en février 2025), cité par le guide d'accompagnement de 2025.
- **PNNS 5 (2026-2030) / SNANC** : le PNNS 5, lancé le 8 avril 2026, met l'accent sur les milieux de vie et sur la réduction des inégalités sociales de santé en nutrition (voir le chapitre 1).

Comment se calcule le niveau de littératie dans l'enquête HLS19

Pour lire correctement les chiffres de HLS19, il faut savoir comment le niveau de chaque personne est obtenu. La version courte utilisée dans de nombreux pays, le questionnaire **HLS19-Q12**, pose 12 questions du type « À quel point est-il facile pour vous de… ». Chaque question a quatre réponses possibles : très facile, facile, difficile, très difficile.

Méthode pas à pas – Du questionnaire au niveau de littératie (HLS19-Q12)

1. On compte les réponses valides (on retire les « je ne sais pas »). Un score n'est calculé que si la personne a répondu à la grande majorité des questions.

2. On compte les réponses « facile » ou « très facile ».

3. Score = réponses faciles ou très faciles / réponses valides × 100 (de 0 à 100).

4. On classe le score : plus de 83,3 = excellent ; plus de 66,7 à 83,3 = suffisant ; plus de 50 à 66,7 = problématique ; 50 ou moins = insuffisant. Les niveaux « problématique » et « insuffisant » forment la littératie **limitée**.

Calcul détaillé – Trois personnes interrogées (données fictives)

- Mme A. répond « facile » ou « très facile » à 9 questions sur 12 : 9 / 12 × 100 = **75,0** : niveau **suffisant**.
- M. B. répond facilement à 8 questions sur 12 : 8 / 12 × 100 = **66,7** : niveau **problématique**.
- Mme C. répond « je ne sais pas » à une question et facilement à 6 des 11 autres : 6 / 11 × 100 = **54,5** : niveau **problématique**. Si l'on avait divisé par 12, on aurait trouvé 50,0 et classé à tort Mme C. au niveau insuffisant.

Leçon : un pourcentage se calcule sur les réponses valides, et une valeur placée juste sur un seuil doit être classée avec soin.

Attention – Ce que mesure vraiment ce score

Le score mesure la **difficulté ressentie** face à des tâches d'information, pas une compétence testée. Deux biais sont possibles : une personne peut surestimer sa facilité par fierté, ou la sous-estimer par manque de confiance. Les niveaux servent à comparer des groupes et des pays, pas à juger un individu.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.4

Lors d'un diagnostic, un questionnaire inspiré du HLS19-Q12 donne les résultats suivants pour quatre personnes : a) 12 réponses valides dont 11 faciles ; b) 12 réponses valides dont 7 faciles ; c) 10 réponses valides dont 5 faciles ; d) 12 réponses valides dont 9 faciles. Calculez les scores et classez chaque personne.

Corrigé

a) 11 / 12 × 100 = 91,7 : excellent. b) 7 / 12 × 100 = 58,3 : problématique. c) 5 / 10 × 100 = 50,0 : insuffisant (50 ou moins). d) 9 / 12 × 100 = 75,0 : suffisant. Deux personnes sur quatre (b et c) ont une littératie limitée. On rappelle que, sur un si petit nombre, le résultat ne décrit pas un public : il sert seulement à s'entraîner au calcul.

D'autres sources pour décrire les compétences d'un public

L'enquête HLS19 n'est pas la seule source utile pour préparer un diagnostic. Trois autres sources aident à situer les compétences de base d'une population, à condition de bien savoir ce que chacune mesure.

Source	Ce qu'elle mesure	Ce que l'on retient pour un projet
Enquête internationale sur les compétences des adultes (PIAAC, OCDE ; 2e cycle réalisé en 2022-2023, résultats publiés en décembre 2024)	Compétences testées en lecture (littératie), en calcul (numératie) et en résolution de problèmes, chez les 16-65 ans	Les scores moyens des adultes en France sont inférieurs à la moyenne de l'OCDE ; 28 % ont une faible maîtrise de l'écrit (Dares, 2024) ; une part importante des adultes ne dépasse pas les niveaux les plus bas, surtout parmi les moins diplômés et les plus âgés
Tests de lecture de la Journée défense et citoyenneté (DEPP, chaque année)	Lecture des jeunes Français de 16 à 25 ans	En 2025, **14 %** des jeunes sont en difficulté de lecture, dont **6 %** en très grande difficulté, assimilable à l'illettrisme (DEPP, note n° 26.43, octobre 2026)
Enquête TIC ménages (Insee)	Usage d'internet et compétences numériques des 16-74 ans	L'illectronisme (7 % en 2025, contre 10 % en 2021) est beaucoup plus fréquent chez les personnes âgées, peu diplômées et aux revenus modestes
Données locales (centres sociaux, associations d'apprentissage du français, France Services)	Demandes d'aide, publics accueillis	Elles décrivent le terrain réel du projet, mais seulement pour les personnes qui viennent déjà

Méthode pas à pas – Utiliser ces chiffres dans un diagnostic, sans erreur

1. Citer la source, l'année et la population exacte (âge, territoire).

2. Ne pas additionner des indicateurs différents (illettrisme, illectronisme, littératie en santé).

3. Ne pas appliquer un pourcentage national à un quartier sans dire que c'est une **estimation**.

4. Compléter par des données locales et par des entretiens avec les acteurs du terrain.

5. Présenter les chiffres comme un **besoin d'adaptation** des actions, jamais comme un défaut des habitants.

Exemple – Une phrase de diagnostic bien construite

« Selon l'Insee (enquête 2025, publiée en 2026), 7 % des 16-74 ans sont en situation d'illectronisme en France et 34 % ont des difficultés numériques ; cette part est plus élevée chez les personnes âgées. Le club de retraités compte 120 adhérents ; lors de notre recueil, 22 des 80 adhérents présents disent n'avoir jamais utilisé internet. Nous prévoyons donc une inscription par téléphone et sur papier. »

À vous de jouer – Exercice d'application 5.5

Un étudiant écrit dans son diagnostic : « Dans le quartier, 7 % + 34 % + 44 % = 85 % des habitants ont des problèmes de littératie. » Relevez les trois erreurs et réécrivez la phrase.

Corrigé

Erreurs : il additionne des indicateurs qui mesurent des choses différentes ; il compte plusieurs fois les mêmes personnes ; il applique des chiffres nationaux, portant sur des populations différentes (18-65 ans scolarisés en France, 16-74 ans, adultes), au quartier sans le dire. Réécriture : « En France, environ 44 % des adultes ont une littératie en santé limitée (HLS19, 2021) et 34 % des 16-74 ans ont des difficultés numériques (Insee, 2025). Ces chiffres nationaux ne décrivent pas directement le quartier ; nous les complétons par les données du centre social. »

5.3.3 Pourquoi la littératie compte en santé publique

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M2 S2 §6 (p. 18)

Les conséquences d'une littératie limitée

Les revues de la littérature (Berkman et coll., 2011, pour l'agence américaine AHRQ) associent un faible niveau de littératie en santé à :

- un **moindre recours à la prévention** (dépistages, vaccinations) et un recours plus tardif aux soins ;
- davantage d'**hospitalisations** et de passages aux urgences ;
- une moins bonne **compréhension des traitements** et des conseils (posologies, régimes prescrits) ;
- une moins bonne **gestion des maladies chroniques** (diabète, insuffisance cardiaque) ;
- un état de santé perçu plus mauvais et une mortalité plus élevée chez les personnes âgées.

En nutrition, une littératie limitée rend plus difficile la lecture des étiquettes, la compréhension des portions et des fréquences (« 5 fruits et légumes », « au moins 2 fois par semaine »), le tri entre informations fiables et publicités.

Littératie et inégalités sociales de santé

Lien diététique – Retour au chapitre 2

La littératie est à la fois un **déterminant** de la santé et un **médiateur** des inégalités : les personnes défavorisées ont plus souvent une littératie limitée, et les messages de prévention écrits, abstraits ou numériques profitent d'abord aux personnes les plus favorisées. Une campagne non adaptée peut donc **creuser** le gradient social (effet « loi inverse des soins »). L'**universalisme proportionné** (Marmot, 2010) consiste à proposer une action à tous, avec une intensité et des modalités adaptées : la communication accessible en fait partie.

Exemple – Le Nutri-Score : un outil pensé pour la littératie

Le Nutri-Score a été conçu comme un logo **synthétique**, coloré et gradué (A à E), précisément parce que le tableau nutritionnel (pour 100 g, en kJ et en kcal) est difficile à utiliser pour une grande partie des consommateurs. Les études ont montré qu'il améliore la capacité à classer les produits selon leur qualité nutritionnelle, y compris chez les personnes ayant un faible niveau d'études. Il ne dispense pas d'expliquer : comparer **au sein d'une même famille** de produits, regarder aussi la liste d'ingrédients.

Par quels chemins la littératie agit-elle sur la santé ?

Constater qu'une littératie limitée est associée à une moins bonne santé ne dit pas **pourquoi**. Paasche-Orlow et Wolf (2007) ont proposé un modèle qui décrit trois chemins principaux. Il aide à choisir où agir dans un projet.

Chemin (Paasche-Orlow et Wolf, 2007)	Ce qui se passe	Exemple en nutrition	Où agir
Accès aux soins et à la prévention	La personne trouve mal les services, renonce aux démarches, arrive plus tard	Une famille ne demande pas le tarif social de la cantine ; un patient ne prend pas rendez-vous avec la diététicienne	Simplifier les démarches, accompagner, aller vers les publics
Relation avec les professionnels	L'échange est moins riche : moins de questions, moins de compréhension, moins de décision partagée	Un patient repart avec un plan alimentaire qu'il n'a pas compris et n'ose pas le dire	Former les professionnels, faire dire, donner du temps
Prendre soin de soi au quotidien	La personne applique moins bien les conseils et gère moins bien sa maladie	Une personne vivant avec un diabète ne sait pas adapter son repas quand elle mange à l'extérieur	Éducation pratique, supports simples, entraînement avec des aliments réels

Le modèle rappelle que la littératie ne joue pas seule : l'âge, la langue, les revenus, la culture, mais aussi la complexité du système de santé interviennent. Il montre surtout que les professionnels et les organisations sont sur deux des trois chemins.

À retenir – Trois chemins, trois leviers

Accès (simplifier et accompagner), relation (communiquer clairement et vérifier), autonomie au quotidien (éduquer avec des situations concrètes). Un projet efficace agit sur au moins deux de ces chemins.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.6

Mme L., 58 ans, a appris qu'elle a une hypertension. Elle a reçu un dépliant sur le sel et n'est pas venue à l'atelier du centre de santé, car l'inscription se faisait en ligne. Lors d'une consultation, elle a dit « oui » à toutes les questions. Repérez, pour chacun des trois chemins du modèle, un élément de la situation, puis proposez une action par chemin.

Corrigé

Accès : l'inscription en ligne l'a empêchée de venir à l'atelier ; action : inscription par téléphone ou à l'accueil. Relation : elle a dit « oui » à tout, sans que l'on vérifie sa compréhension ; action : faire dire, questions ouvertes, un seul message par consultation. Autonomie au quotidien : un dépliant ne suffit pas à savoir repérer le sel caché ; action : atelier pratique avec des emballages et une recette de plat peu salé, remise d'une fiche en images.

Le coût d'une littératie limitée

Plusieurs études ont essayé d'estimer ce que coûte au système de santé une littératie limitée, à cause des hospitalisations évitables, des complications des maladies chroniques et des passages aux urgences. Aux États-Unis, Vernon et coll. (2007) l'estimaient entre 106 et 238 milliards de dollars par an. Une revue européenne (Eichler et coll., 2009) concluait à un surcoût de l'ordre de **3 à 5 %** des dépenses totales de santé. Ces chiffres sont des ordres de grandeur, calculés avec des méthodes et dans des systèmes de santé différents.

Calcul détaillé – Ce que représente un ordre de grandeur de 3 à 5 % (exemple fictif)

Un territoire de santé dépense 400 millions d'euros par an pour les soins de ses habitants (donnée fictive).

- Hypothèse basse : 400 × 3 / 100 = **12 millions d'euros**.
- Hypothèse haute : 400 × 5 / 100 = **20 millions d'euros**.
- Un programme de formation de 50 professionnels à la communication claire coûte 25 000 € (donnée

fictive) : il représente 25 000 / 12 000 000 × 100 = **0,21 %** de l'hypothèse basse.

Interprétation : on ne peut pas en déduire que le programme « rapportera » 12 millions. Le calcul montre seulement que l'enjeu financier est important au regard du coût des actions ; l'efficacité réelle d'un programme doit être évaluée.

Attention – Un argument à manier avec respect

L'argument économique peut convaincre un financeur, mais il ne doit pas faire des personnes à littératie limitée un « coût ». Dans un dossier de projet, on le présente avec l'argument de **justice sociale** : rendre l'information accessible est d'abord une question d'égalité d'accès à la santé (chapitre 2).

Littératie et alimentation : ce que montrent les études

Les travaux sur la littératie et l'alimentation montrent des associations cohérentes : une littératie en santé limitée va souvent avec une moins bonne compréhension des étiquettes et des portions, un usage moins fréquent des informations nutritionnelles et, dans certaines études, une alimentation de moins bonne qualité. Ces associations sont en partie expliquées par le niveau d'études et les revenus, qui jouent sur les deux à la fois : on parle de **facteurs de confusion** (chapitre 16). C'est pourquoi les actions efficaces combinent l'éducation et l'amélioration de l'environnement (prix, offre, étiquetage simple comme le Nutri-Score).

À vous de jouer – Exercice d'application 5.7

Une étude observe que les personnes à littératie limitée consomment moins de fruits et légumes. Un élu conclut : « Il suffit de leur apprendre à lire les étiquettes. » Expliquez pourquoi cette conclusion est trop rapide.

Corrigé

L'étude montre une association, pas une cause. Les personnes à littératie limitée ont souvent aussi des revenus plus faibles et moins accès à des commerces de fruits et légumes : ces facteurs de confusion peuvent expliquer une partie de la différence. Apprendre à lire une étiquette est utile, mais ne règle ni le prix ni l'offre. L'action doit combiner éducation, accès (prix, marché, paniers) et information simple.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.2 et 5.3.3 – Données et enjeux

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle part des adultes a une littératie en santé limitée en France selon HLS19 ? Et quelles sont les deux catégories qui la composent ?
2. Une personne répond facilement à 8 questions sur 12 du HLS19-Q12. Calculez son score et donnez son niveau.
3. Pourquoi ne peut-on pas additionner les taux d'illettrisme et d'illectronisme ?
4. Citez les trois chemins du modèle de Paasche-Orlow et Wolf (2007).
5. Citez trois conséquences d'une littératie limitée sur la santé.
6. Qu'est-ce qu'un facteur de confusion dans l'association entre littératie et alimentation ?

Corrigé – Point d'étape 5.3.2 et 5.3.3

1. Environ 44 % ; littératie « problématique » (environ 30 %) et « insuffisante » (environ 14 %).
2. 8 / 12 × 100 = 66,7 : niveau problématique (de plus de 50 à 66,7).
3. Ils mesurent des choses différentes, sur des populations différentes, et une même personne peut être

comptée dans les deux.

4. L'accès aux soins et à la prévention ; la relation avec les professionnels ; la capacité à prendre soin de soi au quotidien.
5. Moins de prévention, plus d'hospitalisations et de passages aux urgences, moins bonne compréhension des traitements, moins bonne gestion des maladies chroniques.
6. Un facteur, comme le revenu ou le niveau d'études, lié à la fois à la littératie et à l'alimentation, qui peut expliquer une partie de leur association.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux de données et le modèle des trois chemins, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis les sections 5.3.2 et 5.3.3 et je refais les exercices d'application.

5.3.4 Repérer sans stigmatiser

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Méthode pas à pas – L'approche des « précautions universelles »

Il est impossible de savoir, en regardant quelqu'un, s'il a des difficultés de littératie ; les personnes les **cachent** souvent par honte. Plutôt que de « tester » le public, on applique à **tous** une communication claire : c'est l'approche des **précautions universelles** (*health literacy universal precautions*, AHRQ). Tout le monde y gagne, et personne n'est désigné.

Signaux possibles (à interpréter avec prudence)	Exemples
Évitement de l'écrit	« J'ai oublié mes lunettes », « Je le lirai chez moi », formulaire rempli par un proche
Difficultés avec les chiffres	Confusion entre grammes et kilos, entre 100 g et la portion, difficulté à calculer un prix au kilo
Questions déjà traitées dans le document	Demander ce qui est écrit sur le support distribué
Faible participation à l'écrit	Questionnaires non remplis, fiches recettes non utilisées
Difficultés numériques	Pas d'adresse mail, inscription en ligne impossible, smartphone utilisé seulement pour appeler

Méthode pas à pas – Questions simples pour adapter, sans juger

- « Comment préférez-vous recevoir les informations : par écrit, en vidéo, en parlant ? »
- « Est-ce que quelqu'un vous aide habituellement pour les papiers ? »
- « Dans quelle langue êtes-vous le plus à l'aise ? »
- Dans un questionnaire de diagnostic : proposer une passation **orale** (entretien) ou avec pictogrammes, plutôt qu'un questionnaire écrit autoadministré.

Faut-il mesurer la littératie de chaque personne ? Les outils et le débat

Des outils de mesure individuelle existent depuis les années 1990. Ils sont utiles en **recherche** et pour évaluer un programme, mais leur usage pour trier les personnes dans un atelier ou une consultation est discuté.

Outil	Principe	Durée	Usage raisonnable
REALM (Davis et coll., 1993)	La personne lit à voix haute une liste de mots médicaux ; on compte les mots bien prononcés	2 à 3 minutes	Recherche ; il mesure la lecture de mots, pas la compréhension
TOFHLA et sa version courte (Parker et coll., 1995)	Textes à trous et questions sur une ordonnance, un rendez-vous	7 à 22 minutes	Recherche
NVS (Weiss et coll., 2005)	Six questions sur une étiquette de crème glacée (encadré L3, 5.5)	3 minutes	Recherche, évaluation de programmes
Question unique (Chew et coll., 2004)	« Êtes-vous à l'aise pour remplir seul(e) des formulaires médicaux ? »	Moins d'une minute	Repérage rapide en soins, avec tact
Questionnaires de difficulté ressentie (HLS-EU, HLQ)	Autoévaluation de tâches de santé	5 à 20 minutes	Enquêtes de population, diagnostic d'un groupe

Attention – Pourquoi on ne « teste » pas le public d'un atelier

Faire lire une liste de mots ou remplir un test à des adultes venus pour un atelier peut être vécu comme un examen humiliant. La personne peut partir et ne plus revenir. De plus, le résultat ne change presque rien à ce que l'on doit faire : avec les **précautions universelles**, la communication est déjà adaptée à tous. On réserve donc ces outils aux études, avec un consentement éclairé et une présentation respectueuse.

Exemple – Utiliser un outil pour évaluer un programme, pas pour trier les personnes

Un réseau d'éducation thérapeutique veut savoir si son programme améliore la capacité des patients à lire une étiquette. Avec l'accord des participants, il fait passer un court test inspiré du NVS au début et à la fin du programme, de façon anonyme. Il compare les résultats du groupe, sans jamais les utiliser pour exclure ou classer un patient.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.8

Une stagiaire propose de faire lire une liste de mots médicaux à chaque nouveau participant d'un atelier de cuisine, « pour faire des groupes de niveau ». Donnez deux arguments contre cette idée et une alternative.

Corrigé

Arguments : le test peut humilier et faire fuir les personnes qui en ont le plus besoin ; il mesure la lecture de mots médicaux, pas la capacité à cuisiner ou à comprendre une recette ; les groupes de niveau stigmatisent. Alternative : appliquer à tous les précautions universelles (consignes orales et en images, démonstration, binômes mixtes) et demander simplement à l'inscription comment la personne préfère recevoir les informations.

Comprendre la honte pour mieux accueillir

Les difficultés avec l'écrit sont souvent cachées. Parikh et coll. (1996) ont interrogé des patients d'un hôpital américain dont la littératie était limitée : environ **4 sur 10** disaient ressentir de la honte face à leurs difficultés de lecture ; parmi eux, environ **les deux tiers** n'en avaient jamais parlé à leur conjoint, et près d'**un sur cinq** n'en avait jamais parlé à personne. Les personnes développent alors des **stratégies de contournement** très efficaces, qui rendent les difficultés invisibles pour les professionnels.

Stratégie de contournement	Ce que le professionnel peut faire, pour tous
Venir toujours accompagné d'un proche qui lit	Proposer de lire ensemble les documents importants à tous les participants

Stratégie de contournement	Ce que le professionnel peut faire, pour tous
Mémoriser à l'oral ce qui a été dit	Répéter les messages clés en fin de séance ; laisser un support en images
Repérer les produits par la couleur ou la forme de l'emballage	Utiliser de vrais emballages en atelier ; associer couleurs et pictogrammes
Prendre les papiers « pour les lire à la maison »	Remplir les formulaires ensemble, dans un endroit calme
Ne pas revenir quand un écrit est demandé	Réduire l'écrit à l'inscription et à l'évaluation (oral, smileys, gommettes)

À retenir – Une règle d'accueil

Ce n'est pas à la personne de révéler ses difficultés : c'est à la structure de rendre l'information accessible sans que personne n'ait à se signaler. Une phrase neutre, valable pour tous, aide : « Ici, on remplit les papiers ensemble, c'est plus rapide. »

Calcul détaillé – Appliquer des proportions à un groupe (ordre de grandeur, données fictives)

Un programme d'ateliers accueille 60 adultes, dont on estime, d'après le diagnostic, que 25 environ ont une littératie limitée.

- Si 4 sur 10 ressentent de la honte : 25 × 0,4 = **10 personnes**.
- Si les deux tiers d'entre elles n'en ont pas parlé à leur conjoint : 10 × 2 / 3 ≈ **7 personnes**.

Interprétation : ces chiffres viennent d'une étude ancienne et étrangère ; on ne peut pas les appliquer exactement au groupe. Ils montrent simplement qu'une partie du public peut vivre ses difficultés en silence, ce qui justifie une communication claire pour tous.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.9

À la fin d'un atelier, une participante refuse de remplir le questionnaire de satisfaction : « Je n'ai pas le temps, je le ferai la prochaine fois. » Proposez deux façons de recueillir son avis sans la mettre en difficulté, valables pour tout le groupe.

Corrigé

Une évaluation par gommettes sur des smileys pour tout le groupe, avec les questions lues à voix haute ; un tour de parole rapide « Une chose que vous allez refaire ». On peut aussi proposer à chacun de répondre à l'oral à l'animatrice en rangeant la salle. Ces solutions valent pour tous et ne désignent personne.

Les précautions universelles en pratique : la boîte à outils de l'AHRQ

L'agence américaine pour la recherche et la qualité en santé (AHRQ) a publié en 2010, puis révisé, une **boîte à outils des précautions universelles en littératie** (*Health Literacy Universal Precautions Toolkit*). Elle est conçue pour les cabinets et les centres de soins, mais ses principes s'appliquent très bien à une structure de santé publique, à un centre social ou à un service de restauration. Elle s'organise en quatre domaines.

Domaine de la boîte à outils	Exemples d'outils	Adaptation pour une action en nutrition
Améliorer la communication orale	Faire dire, préparer les messages clés, utiliser des mots simples	Trois messages au plus par atelier, démonstration avant explication
Améliorer la communication écrite	Évaluer et simplifier les documents, utiliser des supports adaptés	Fiches recettes en photos testées auprès du public

Domaine de la boîte à outils	Exemples d'outils	Adaptation pour une action en nutrition
Améliorer l'autonomie et le pouvoir d'agir	Fixer des objectifs avec la personne, l'encourager à poser des questions	Chaque participant choisit une action à essayer chez lui
Améliorer les systèmes de soutien	Orienter vers les aides, faciliter les démarches, s'occuper des besoins non médicaux	Lien avec l'épicerie solidaire, aide à l'inscription à la cantine, contact France Services

Méthode pas à pas – Lancer une démarche de précautions universelles dans une structure

1. **Constituer une petite équipe** : un responsable, un professionnel de terrain, un usager.
2. **Faire un état des lieux** : relire les documents, observer l'accueil, demander l'avis de quelques usagers.
3. **Choisir deux ou trois améliorations** faciles et visibles (signalétique, inscription, fiches).
4. **Tester** chaque amélioration avec des usagers avant de la généraliser.
5. **Former** toute l'équipe, y compris l'accueil et les bénévoles.
6. **Suivre** quelques indicateurs : nombre d'inscriptions par téléphone, réussite des « faire dire », documents testés.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.10

Une épicerie solidaire veut appliquer les précautions universelles. Proposez une action pour chacun des quatre domaines de la boîte à outils.

Corrigé

Communication orale : les bénévoles présentent oralement les nouveaux produits du mois et vérifient avec « montrez-moi ». Communication écrite : affichage des prix avec des chiffres en gros et des pictogrammes de familles d'aliments, testé avec des bénéficiaires. Autonomie : à chaque atelier, chacun choisit une recette à refaire et la raconte la fois suivante. Systèmes de soutien : un point d'aide aux démarches (CAF, cantine) avec un partenaire, et une orientation vers France Services.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.4 – Repérer sans stigmatiser

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Définissez l'approche des précautions universelles.
2. Citez trois signaux possibles de difficulté avec l'écrit.
3. Pourquoi un signal n'est-il jamais une preuve ?
4. Citez un outil de mesure individuelle de la littératie et dites dans quel cadre on peut l'utiliser.
5. Citez deux stratégies de contournement utilisées par des personnes qui cachent leurs difficultés.
6. Citez les quatre domaines de la boîte à outils de l'AHRQ.

Corrigé – Point d'étape 5.3.4

1. Appliquer à tout le public une communication claire, au lieu de chercher à repérer ou tester les personnes en difficulté.
2. « J'ai oublié mes lunettes », formulaire rempli par un proche, questions sur ce qui est déjà écrit, difficulté avec les chiffres, pas d'adresse mail.
3. Parce qu'il peut avoir d'autres causes (fatigue, oubli réel, manque de temps) ; on ne pose pas de diagnostic sur une personne.
4. REALM, TOFHLA, NVS ou la question unique de Chew ; en recherche ou pour évaluer un programme, avec

consentement, jamais pour trier les participants.

5. Venir avec un proche qui lit, mémoriser à l'oral, repérer les produits par la couleur, emporter les papiers « pour les lire à la maison ».

6. Communication orale, communication écrite, autonomie et pouvoir d'agir, systèmes de soutien.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section 5.3.4 et je refais les exercices d'application.

5.3.5 Adapter les messages et les supports

Module · Guide 2025 : p. 61 ; p. 122 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

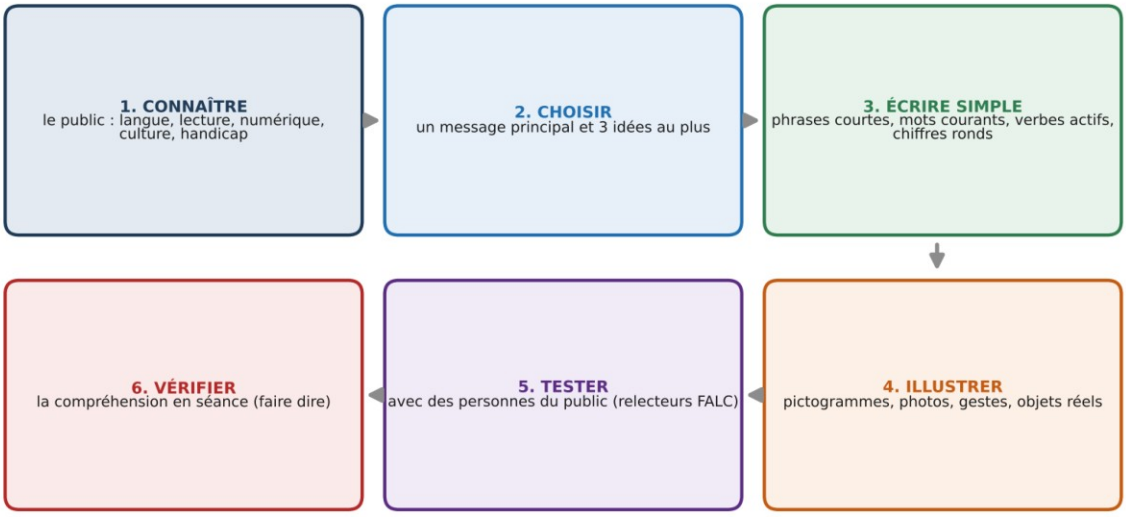


Figure 5.5 – Six étapes pour une communication accessible

Comprendre le schéma – Figure 5.5

1. Connaître le public : langue, maîtrise de l'écrit, accès au numérique, culture, handicap (visuel, auditif, cognitif) ; le diagnostic (chapitre 7) doit recueillir ces informations.

2. Choisir un message principal et au plus trois idées secondaires : trop d'informations noient l'essentiel.

3. Écrire simple : phrases courtes (une idée par phrase), mots courants, verbes actifs, pas de sigles, chiffres ronds et concrets (« une poignée » plutôt que « 30 g »).

4. Illustrer : pictogrammes, photos réalistes, objets réels (emballages, verres, cuillères), gestes ; l'image doit dire la même chose que le texte.

5. Tester le support auprès de personnes du public (relecteurs, groupe test) avant de l'imprimer.

6. Vérifier la compréhension en séance par le « faire dire ».

Les règles d'écriture claire (guide « Communiquer pour tous »)

Règle	À éviter	À préférer
Une idée par phrase, 15 mots au plus	« Afin de favoriser un apport suffisant en fibres, il est recommandé de privilégier les féculents complets lors de chacun des repas. »	« Mangez du pain complet ou des pâtes complètes. Ils contiennent des fibres. »
Mots courants	Légumineuses, apports, privilégier	Lentilles, pois chiches, haricots secs ; manger ; choisir
Forme active et directe	« Il est conseillé de limiter… »	« Mangez moins de… »
Phrases positives	« Ne pas oublier de boire »	« Buvez de l'eau »
Chiffres concrets	« 400 g de fruits et légumes par jour »	« 5 fruits et légumes par jour : une portion = la taille d'un poing »
Pas de sigles	PNNS, AJR, IMC	« Les conseils officiels » ; expliquer si nécessaire
Mise en page aérée	Texte justifié, italique, majuscules, police fantaisie	Police sans empattement, 14 points au moins, aligné à gauche, gras pour l'essentiel, puces
Image utile	Image décorative ou ambiguë	Photo réelle du geste ou de l'aliment

Définition – FALC – Facile à lire et à comprendre

Méthode de rédaction issue des **règles européennes** (Inclusion Europe, 2009), conçue avec et pour les personnes en situation de **handicap intellectuel**, mais utile à beaucoup d'autres publics (personnes âgées, personnes apprenant le français, personnes fatiguées ou stressées). Un document FALC est **relu et validé** par des personnes concernées et peut porter le logo européen « Facile à lire ». Exemple de ressource en santé : *SantéBD*, bandes dessinées en FALC pour expliquer la santé et les consultations.

Mesurer la lisibilité d'un texte

La **lisibilité** d'un texte dépend de la longueur des phrases et des mots. L'indice de **Flesch**, adapté au français par Kandel et Moles (1958), en donne une estimation :

Méthode pas à pas – Indice de lisibilité de Kandel et Moles (adaptation française de Flesch)

L = 207 − 1,015 × (nombre de mots / nombre de phrases) − 73,6 × (nombre de syllabes / nombre de mots)
Interprétation (échelle de Flesch) : 0-30 très difficile ; 30-50 difficile ; 50-60 assez difficile ; 60-70 standard ; 70- 80 assez facile ; 80-90 facile ; 90-100 très facile.

Exemple – Calcul détaillé : un dépliant avant et après réécriture

Version initiale : 120 mots, 5 phrases, 204 syllabes.

- Mots par phrase : 120 / 5 = **24** ; syllabes par mot : 204 / 120 = **1,7**.
- L = 207 − 1,015 × 24 − 73,6 × 1,7 = 207 − 24,36 − 125,12 = **57,52** → « assez difficile ».

Version réécrite : 96 mots, 12 phrases, 144 syllabes.

- Mots par phrase : 96 / 12 = **8** ; syllabes par mot : 144 / 96 = **1,5**.
- L = 207 − 1,015 × 8 − 73,6 × 1,5 = 207 − 8,12 − 110,4 = **88,48** → « facile ».

Gain : 88,48 − 57,52 = **30,96 points**. Limite : l'indice ne mesure ni le sens, ni la mise en page, ni l'adéquation au public ; il complète le test auprès des personnes, il ne le remplace pas.

Adapter l'oral, l'atelier et le numérique

Support	Adaptations
Oral (séance, atelier)	Parler lentement, mots simples, un message à la fois, reformuler, montrer (gestes, objets), répéter les messages clés en fin de séance, s'appuyer sur l'expérience des participants
Atelier culinaire	Recettes en images (photos de chaque étape), quantités en contenants courants (verre, cuillère, poignée), démonstration avant de faire, binômes mixtes
Écrit (affiche, dépliant)	Un message par affiche, titre qui dit l'essentiel, pictogrammes, tests de compréhension
Numérique (site, réseaux, vidéo)	Vidéos courtes sous-titrées, audio, navigation simple, version papier ou accompagnement (médiateur numérique, France Services) ; ne jamais réserver une inscription au seul numérique
Langues	Traduction professionnelle ou interprétariat (médiation en santé), supports multilingues testés ; éviter les traducteurs automatiques non relus pour des messages de santé
Handicap	Contrastes et grande police (déficience visuelle), sous-titres et langue des signes (déficience auditive), FALC (déficience intellectuelle), accessibilité des locaux

Situer un texte sur l'échelle et compter les syllabes

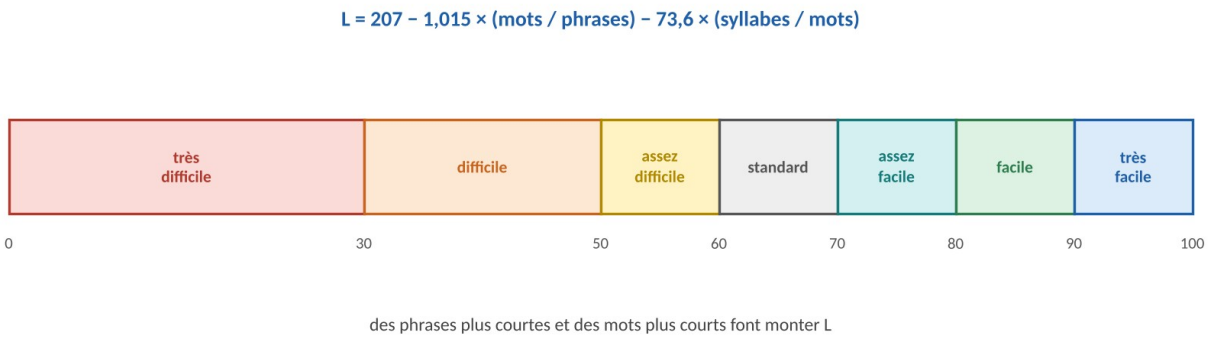


Figure 5.5 bis – L'échelle de lisibilité de Kandel et Moles

Comprendre le schéma – Figure 5.5 bis

1. La barre va de **0** (texte très difficile) à **100** (texte très facile) ; chaque couleur correspond à une catégorie de l'échelle de Flesch reprise par Kandel et Moles (1958).
2. Les zones ne sont pas de même largeur : la zone « très difficile » couvre 0 à 30, alors que les zones « assez difficile » à « très facile » ne couvrent que 10 points chacune. Un gain de 10 points peut donc faire changer de catégorie.
3. La formule rappelle les deux leviers : la **longueur des phrases** (mots par phrase) et la **longueur des mots** (syllabes par mot). Le second pèse beaucoup : passer de 1,7 à 1,5 syllabe par mot fait gagner 73,6 × 0,2 = 14,72 points.
4. Pour un public à littératie limitée, on vise au moins la zone « facile » (80 et plus), puis on teste le support auprès de quelques personnes.

Méthode pas à pas – Compter mots, phrases et syllabes à la main

1. Les mots : chaque groupe de lettres séparé par un espace compte pour un mot ; « l'eau » compte pour deux mots (l' et eau) ; un nombre écrit en chiffres compte pour un mot.

2. Les phrases : on compte les phrases terminées par un point, un point d'exclamation ou d'interrogation ; une liste à puces sans point compte pour une phrase par puce.

3. Les syllabes : on les compte **à l'oreille**, comme on les prononce en parlant normalement ; le « e » muet de fin de mot ne compte pas (« lé-gumes » = 2) ; un sigle ou un nombre se compte comme il se dit (« 14 » = qua-torze = 2).

4. Une seule convention : on garde la même façon de compter pour la version initiale et la version réécrite ; c'est la **comparaison** qui compte, plus que la valeur exacte.

Calcul détaillé – Une phrase comptée pas à pas

« Mangez des légumes à chaque repas. » : man-gez (2) des (1) lé-gumes (2) à (1) chaque (1) re-pas (2) = **9 syllabes** ; **6 mots** ; **1 phrase**.

- Mots par phrase : 6 ; syllabes par mot : 9 / 6 = **1,5**.
- L = 207 − 1,015 × 6 − 73,6 × 1,5 = 207 − 6,09 − 110,4 = **90,51** : très facile.

Remarque : une phrase seule donne un indice peu fiable ; on calcule l'indice sur un passage d'au moins 100 mots, ou sur tout le support s'il est court.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.11

Comptez les mots, les syllabes et calculez l'indice de la consigne suivante : « Lavez vos mains avant de cuisiner. Coupez les carottes en rondelles. » (On compte « ron-delles » = 2 syllabes.)

Corrigé

Mots : 6 + 5 = 11 ; phrases : 2 ; syllabes : la-vez (2) vos (1) mains (1) a-vant (2) de (1) cui-si-ner (3) = 10 ; cou-pez (2) les (1) ca-rottes (2) en (1) ron-delles (2) = 8 ; total 18. Mots par phrase : 11 / 2 = 5,5 ; syllabes par mot : 18 / 11 = 1,636. L = 207 − 1,015 × 5,5 − 73,6 × 1,636 = 207 − 5,58 − 120,44 = 80,98 : facile. Le calcul porte sur un texte très court : il sert ici d'entraînement.

Remplacer les mots du métier par des mots de tous les jours

Le vocabulaire de la nutrition est plein de mots techniques que le professionnel n'entend plus comme difficiles. Une liste de remplacements, établie en équipe et complétée après chaque test de support, fait gagner du temps et rend les documents cohérents.

Mot du métier	Mot ou expression de tous les jours
Légumineuses, légumes secs	Lentilles, pois chiches, haricots secs (donner des exemples)
Féculents	Pain, pâtes, riz, pommes de terre, semoule
Produits laitiers	Lait, yaourt, fromage
Apport, consommation	Ce que l'on mange, ce que l'on boit
Privilégier	Choisir plus souvent
Limiter	Manger moins souvent, en petite quantité
Collation	Petit en-cas, goûter
Hydratation	Boire
Matières grasses ajoutées	Huile, beurre, crème

Mot du métier	Mot ou expression de tous les jours
Aliments ultra-transformés	Produits avec une longue liste d'ingrédients que l'on n'a pas dans sa cuisine
Densité énergétique	Aliment qui apporte beaucoup de calories pour un petit volume
Rassasiement	Se sentir plein à la fin du repas
Glucides complexes	Pain, pâtes, riz (le mot « glucides » est à expliquer s'il est utile)
Portion	Quantité dans l'assiette ; montrer avec la main, un verre, une cuillère
Équilibré	Varié, avec des légumes, un féculent et un peu de viande, de poisson, d'œufs ou de légumes secs

Attention – Simplifier sans infantiliser

Écrire simplement ne veut pas dire écrire comme pour un enfant. On garde un ton adulte, on vouvoie (sauf public d'enfants ou d'adolescents), on évite les diminutifs et les jeux de mots. Si un mot technique est utile, par exemple « allergène » ou « Nutri-Score », on le garde et on l'explique une fois avec des mots simples.

Exemple – Une phrase réécrite en deux temps

Version initiale : « La consommation de féculents complets permet d'augmenter les apports en fibres et de favoriser le rassasiement. » Première réécriture : « Le pain complet et les pâtes complètes contiennent des fibres. » Seconde réécriture, après le test : « Le pain complet et les pâtes complètes calent plus longtemps. » Lors du test, plusieurs personnes ne savaient pas à quoi servent les fibres : l'effet ressenti (« calent plus longtemps ») a été mieux compris que le nom du nutriment.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.12

Réécrivez avec des mots de tous les jours : « Privilégiez les légumineuses et limitez les produits ultra-transformés lors de vos collations. »

Corrigé

« Mangez plus souvent des lentilles, des pois chiches ou des haricots secs. Pour le goûter, choisissez un fruit, du pain ou un yaourt plutôt que des biscuits ou des barres. » On a remplacé chaque mot technique par des exemples concrets et découpé la phrase en deux idées.

Mettre en page pour être lu

Un texte bien écrit peut rester difficile à lire s'il est mal présenté. La mise en page est la première chose que voit le lecteur : elle décide souvent s'il va lire ou non.

Élément	Ce qui aide	Ce qui gêne
Police	Sans empattement (de type Arial, Verdana), 14 points au moins pour un document à lire seul, 12 au minimum	Police fantaisie ou manuscrite, petits caractères
Mise en valeur	Le gras pour les mots importants	L'italique, le souligné en dehors des liens, les MAJUSCULES sur des phrases entières
Alignement	Texte aligné à gauche, une phrase par ligne si possible	Texte justifié (espaces irréguliers), phrase coupée entre deux pages
Espace	Interligne large, marges, paragraphes courts, beaucoup de blanc	Page pleine, texte serré

Élément	Ce qui aide	Ce qui gêne
Structure	Titre qui dit l'essentiel, intertitres sous forme de question, puces	Titre abstrait, longs paragraphes
Couleurs	Texte foncé sur fond clair, contraste fort	Texte sur une photo, couleurs pâles, information donnée seulement par la couleur
Images	Une image à côté du texte qu'elle illustre	Image décorative, éloignée du texte
Chiffres	En chiffres (« 3 verres »), unités connues	Chiffres en lettres longues, grands nombres, pourcentages non expliqués

Méthode pas à pas – Relire un support en 5 minutes avant de le tester

1. Le titre dit-il ce que le lecteur va trouver ou faire ?

2. Y a-t-il un seul message principal, visible en premier ?

3. Chaque phrase fait-elle moins de 15 mots ?

4. La police, la taille et le contraste respectent-ils le tableau ci-dessus ?

5. Chaque image dit-elle la même chose que le texte voisin ?

6. Le lecteur sait-il quoi faire à la fin (venir, appeler, essayer une recette) ?

À vous de jouer – Exercice d'application 5.13

Une affiche pour un atelier est écrite en majuscules italiques jaunes sur la photo d'un marché. Le titre est « PROGRAMME ALIMENTATION SANTÉ ». Relevez quatre défauts et proposez une nouvelle présentation.

Corrigé

Défauts : majuscules et italique difficiles à lire ; texte jaune sur une photo, contraste faible ; titre abstrait qui ne dit pas ce que l'on va faire ; aucune information pratique visible. Nouvelle présentation : fond blanc, titre en gras noir « Cuisinons ensemble le mardi », photo de personnes qui cuisinent placée à côté du texte, trois informations avec pictogrammes (horloge : mardi 14 h ; lieu : salle du rez-de-chaussée ; pièce barrée : gratuit), contact téléphonique en gros.

Les images qui aident et celles qui trompent

Une revue de la littérature de Houts et coll. (2006) a montré que des images bien choisies, placées à côté d'un texte ou d'une explication orale, améliorent l'**attention**, la **compréhension**, la **mémorisation** et l'**application** des consignes de santé, surtout chez les personnes à littératie limitée. Mais une image peut aussi tromper : elle doit être choisie, puis testée.

Image qui aide	Image qui trompe ou gêne
Photo réelle d'un geste (rincer les lentilles)	Dessin humoristique dont on ne comprend pas le sens
Photo d'une portion à côté d'une main ou d'un verre	Photo d'une assiette sans repère de taille
Pictogramme simple, toujours le même pour la même idée	Pictogramme différent à chaque page pour la même idée
Image qui montre ce qu'il faut faire	Image qui montre seulement ce qu'il ne faut pas faire (le geste « interdit » est souvent retenu)
Personnes diverses, dans des situations réalistes	Corps idéalisés, images qui stigmatisent (personne en surpoids triste)

Attention – Un pictogramme n'est pas universel

Un même pictogramme peut être compris différemment selon la culture, l'âge ou l'habitude. Une croix rouge peut vouloir dire « interdit » ou « soins » ; une main levée peut vouloir dire « stop » ou « bonjour ». Les normes de conception des pictogrammes publics (série ISO 9186) prévoient d'ailleurs de **tester leur compréhension** auprès du public avant de les utiliser.

Calcul détaillé – Tester quatre pictogrammes d'allergènes (données fictives)

On montre quatre pictogrammes, sans texte, à 15 parents d'une crèche, et l'on demande « Qu'est-ce que cela veut dire ? ». Dans ce cours, on retient qu'un pictogramme est **validé** si au moins deux personnes sur trois le comprennent (66,7 %).

- Lait (verre de lait) : 14 / 15 × 100 = **93,3 %** : validé.
- Œuf : 13 / 15 = **86,7 %** : validé.
- Gluten (épi de blé) : 8 / 15 = **53,3 %** : non validé ; plusieurs parents ont répondu « céréales » ou « pain ».
- Fruits à coque (noisette) : 9 / 15 = **60,0 %** : non validé.

Décision : on garde les deux premiers ; pour le gluten et les fruits à coque, on ajoute le mot sous l'image et des exemples d'aliments (« blé : pain, pâtes, gâteaux »), puis on refait le test.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.14

Pour une fiche sur l'hygiène en cuisine, une collègue propose trois images : une main barrée devant un réfrigérateur, la photo d'une personne qui se lave les mains, un dessin de microbe souriant. Dites lesquelles garder et pourquoi.

Corrigé

On garde la photo d'une personne qui se lave les mains : elle montre le geste attendu. La main barrée est ambiguë (on ne sait pas ce qui est interdit) et montre ce qu'il ne faut pas faire. Le microbe souriant donne une image positive de ce qu'on veut éviter et n'apporte aucune information. On peut ajouter une photo du réfrigérateur rangé correctement, avec un mot sous chaque zone.

Écrire en FALC pas à pas

Les règles européennes du FALC ont été publiées en 2009 par Inclusion Europe dans le guide *L'information pour tous*, rédigé avec des personnes en situation de handicap intellectuel. Elles vont plus loin que l'écriture claire : chaque règle est pensée pour une personne qui lit peu ou lentement et qui a besoin de repères stables.

Étape	Règles principales du FALC
Avant d'écrire	Savoir qui va lire et ce qu'il doit savoir ou faire ; associer dès le début des personnes concernées
Les mots	Mots simples et connus ; expliquer un mot difficile la première fois ; toujours le même mot pour la même chose ; pas de mots d'une autre langue, pas d'abréviations ni de sigles ; pas d'images de langage (« avoir un petit creux »)
Les phrases	Phrases courtes, une idée par phrase ; forme active et positive ; s'adresser directement au lecteur (« vous ») ; les idées dans l'ordre où elles se passent
Les nombres	En chiffres (« 3 » et non « trois ») ; éviter les pourcentages et les grands nombres (« beaucoup de personnes ») ; dates écrites en entier (« mardi 12 janvier »)
La mise en page	Police claire et grande, pas d'italique, texte aligné à gauche, une phrase par ligne si possible, ne pas couper une phrase entre deux pages ; images à côté du texte

Étape	Règles principales du FALC
Après l'écriture	Faire relire par des personnes concernées ; corriger ; elles valident le document, qui peut alors porter le logo européen « Facile à lire »

Exemple – Une consigne d'hygiène réécrite en FALC

Version initiale : « Le lavage des mains, réalisé avant toute manipulation de denrées et après chaque passage aux sanitaires, constitue une mesure d'hygiène essentielle. »

Version FALC (avec une photo à gauche de chaque ligne) :

- « Lavez vos mains avec du savon. »
- « Lavez vos mains avant de cuisiner. »
- « Lavez vos mains après être allé aux toilettes. »
- « Lavez vos mains pendant 30 secondes. Chantez une petite chanson dans votre tête. »

Le verbe « lavez » est répété : en FALC, la répétition aide à repérer l'information.

Attention – FALC, écriture claire : ne pas confondre

L'écriture claire s'adresse à tout le monde et le professionnel peut l'appliquer seul. Le FALC est une méthode précise, conçue avec et pour les personnes en situation de handicap intellectuel ; un document n'est FALC que s'il a été **relu et validé** par des personnes concernées. Des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) et des associations proposent ce travail de relecture, qui doit être reconnu et, si possible, rémunéré.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.15

Réécrivez en FALC l'invitation suivante, pour des adultes d'un foyer d'hébergement : « Un atelier de sensibilisation à l'équilibre alimentaire aura lieu le 12/03/2027 à 14h30 au réfectoire ; la participation de 80 % des résidents est souhaitée. »

Corrigé

« Venez cuisiner avec nous. » « C'est le vendredi 12 mars 2027. » « Nous commençons à 14 heures 30. » « C'est dans la salle à manger. » « Nous allons préparer un repas bon pour la santé. » « Nous voulons que beaucoup de personnes viennent. » (Photos : des personnes qui cuisinent, une horloge, la salle à manger.) Le pourcentage a été remplacé par « beaucoup de personnes », la date est écrite en entier avec le jour de la semaine, le jargon (« sensibilisation », « équilibre alimentaire ») a disparu. Le document est ensuite relu par des résidents.

D'autres formules de lisibilité, et pourquoi on ne les mélange pas

La formule de Kandel et Moles est une adaptation au français de la formule de Rudolf **Flesch** (1948), conçue pour l'anglais : L = 206,835 − 1,015 × (mots / phrases) − 84,6 × (syllabes / mots). Les mots français ont en moyenne plus de syllabes que les mots anglais ; Kandel et Moles (1958) ont donc réduit le poids des syllabes (73,6 au lieu de 84,6) pour que les scores des deux langues restent comparables. D'autres indices existent, par exemple l'indice **Gunning Fog** (1952), qui estime un nombre d'années d'études nécessaires à partir de la longueur des phrases et de la part des mots de trois syllabes ou plus, et des outils en ligne en français, comme **Scolarius**, développé au Québec.

Calcul détaillé – Le même texte, deux formules

Un texte français compte 120 mots, 12 phrases et 180 syllabes : 10 mots par phrase, 1,5 syllabe par mot.

- Formule française (Kandel et Moles) : 207 − 1,015 × 10 − 73,6 × 1,5 = 207 − 10,15 − 110,4 = **86,45** : facile.

- Formule anglaise (Flesch) appliquée par erreur : 206,835 − 10,15 − 84,6 × 1,5 = 206,835 − 10,15 − 126,9 = **69,79** : standard.

Un second texte compte 180 mots, 10 phrases et 324 syllabes : 18 mots par phrase, 1,8 syllabe par mot.

- Kandel et Moles : 207 − 18,27 − 132,48 = **56,25** : assez difficile. Flesch : 206,835 − 18,27 − 152,28 = **36,29** : difficile.

Leçon : la formule anglaise sous-estime la lisibilité d'un texte français d'environ 15 à 20 points. On utilise toujours la formule adaptée à la langue, et on ne compare que des scores calculés avec la même formule.

Méthode pas à pas – Utiliser un outil de lisibilité en ligne avec prudence

1. Vérifier quelle formule l'outil utilise et pour quelle langue.

2. Retirer du texte les titres, les listes de chiffres et les tableaux, qui faussent le calcul.

3. Comparer la version initiale et la version réécrite avec le même outil.

4. Ne jamais coller dans un outil en ligne un texte qui contient des données personnelles (nom, situation de santé) : règles du RGPD (chapitre 6).

5. Compléter toujours par la relecture des mots difficiles et par un test auprès du public.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.16

Un collègue annonce que la fiche de l'atelier obtient 62 « d'après un site américain » et qu'il faut tout réécrire. La fiche compte 100 mots, 10 phrases et 160 syllabes. Calculez l'indice de Kandel et Moles et donnez votre avis.

Corrigé

Mots par phrase : 100 / 10 = 10 ; syllabes par mot : 160 / 100 = 1,6. L = 207 − 10,15 − 73,6 × 1,6 = 207 − 10,15 − 117,76 = 79,09 : assez facile, à la limite de « facile ». Le site américain applique sans doute la formule anglaise, qui sous-estime les textes français (206,835 − 10,15 − 84,6 × 1,6 = 61,32, soit environ 62). Il n'est pas nécessaire de tout réécrire : on peut raccourcir quelques mots longs pour dépasser 80, puis tester la fiche auprès de quelques personnes.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.5 – Adapter les messages et les supports

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez dans l'ordre les six étapes d'une communication accessible.

2. Donnez la formule de Kandel et Moles et la zone visée pour un public à littératie limitée.

3. Calculez l'indice d'un texte de 80 mots, 8 phrases et 120 syllabes.

4. Citez trois règles de mise en page qui facilitent la lecture.

5. Qui valide un document FALC ?

6. Pourquoi faut-il tester un pictogramme avant de l'utiliser ?

Corrigé – Point d'étape 5.3.5

1. Connaître le public, choisir un message, écrire simple, illustrer, tester, vérifier par le faire dire.

2. L = 207 − 1,015 × (mots / phrases) − 73,6 × (syllabes / mots) ; on vise 80 et plus (facile ou très facile).

3. 80 / 8 = 10 mots par phrase ; 120 / 80 = 1,5 syllabe par mot ; L = 207 − 10,15 − 110,4 = 86,45 : facile.

4. Police sans empattement de 14 points, texte aligné à gauche, gras plutôt qu'italique ou majuscules, contraste fort, images à côté du texte, beaucoup d'espace.

5. Des personnes en situation de handicap intellectuel, qui relisent et valident le document.

6. Parce qu'un pictogramme peut être compris différemment selon la culture, l'âge ou l'habitude ; seul le test montre s'il est compris.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je refais le calcul de lisibilité et je relis les tableaux de la section.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section 5.3.5 et je refais les exercices d'application.

5.3.6 Vérifier la compréhension : le « faire dire »

Module · Guide 2025 : p. 61 ; p. 24-25 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

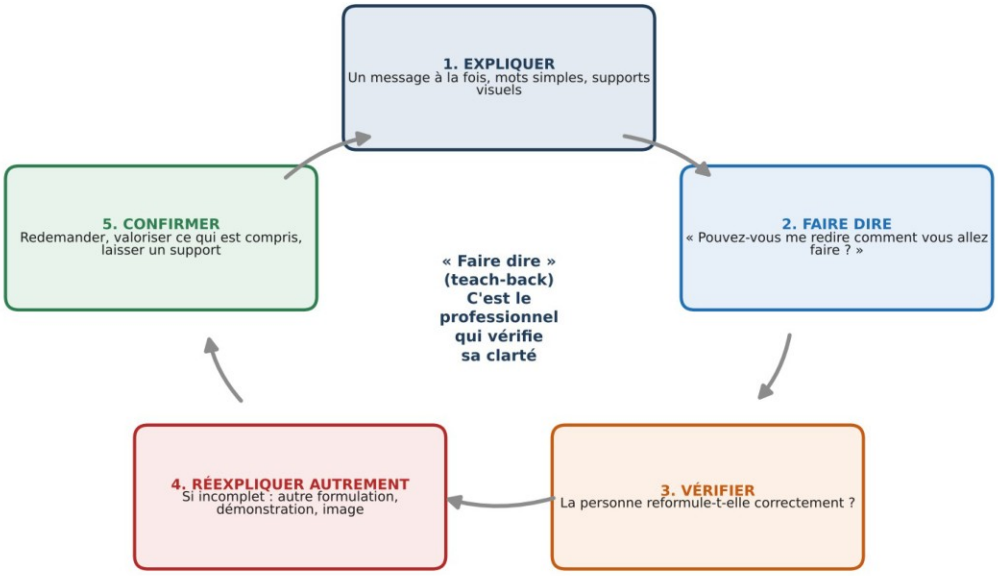


Figure 5.6 – La boucle du « faire dire » (teach-back)

Comprendre le schéma – Figure 5.6

1. Expliquer un message à la fois, avec des mots simples et un support visuel.

2. Faire dire : demander à la personne de reformuler **avec ses mots** ce qu'elle va faire, en présentant la demande comme une vérification de **sa propre clarté** (« Pour être sûr(e) d'avoir bien expliqué… »).

3. Vérifier la reformulation.

4. Si elle est incomplète, **réexpliquer autrement** (autre formulation, démonstration, image), sans répéter mot pour mot.

5. Confirmer par une nouvelle reformulation, valoriser, laisser un support.

6. La HAS a publié en 2015 une fiche-outil « Faire dire » pour les professionnels de santé ; la technique s'utilise aussi en atelier collectif (« Qui peut expliquer à son voisin comment on lit le Nutri-Score ? »).

Attention – Ce qu'il ne faut pas dire

« Vous avez compris ? » appelle presque toujours la réponse « oui », par politesse ou par gêne. On préfère une **question ouverte** qui demande d'agir : « Montrez-moi comment vous choisiriez entre ces deux céréales.

»

À vous de jouer – Exercice d'application 5.17

Réécrivez le message suivant pour des parents ayant une littératie limitée, puis formulez la question de « faire dire » : « Il est recommandé de limiter la consommation de boissons sucrées, y compris les jus de fruits, qui ne doivent pas excéder un verre par jour, et de privilégier l'eau, seule boisson indispensable. »

Corrigé

Réécriture : « L'eau est la meilleure boisson. Les sodas et les jus ont beaucoup de sucre. Les jus de fruits : un petit verre par jour, pas plus. » (avec un pictogramme verre d'eau en vert, soda en rouge). **Faire dire** : « Pour être sûre d'avoir été claire : qu'est-ce que vous allez donner à boire à vos enfants au goûter demain ? »

Découper, vérifier, faire faire : trois façons d'utiliser le « faire dire »

Le principe du « faire dire » et son usage en groupe ont été présentés au chapitre 3. En littératie, on l'utilise sous trois formes complémentaires.

Forme	Ce que l'on fait	Quand l'utiliser
Découper et vérifier (*chunk and check*)	On donne une information à la fois, puis on vérifie avant de passer à la suivante	Explication longue : un plan alimentaire, une recette en plusieurs étapes, une démarche administrative
Faire faire (*show me*)	On demande de **montrer** le geste plutôt que de le dire : verser une portion, lire une étiquette, régler une plaque	Gestes techniques, numératie (quantités, prix), public allophone
Faire dire à distance	Au téléphone ou en visioconférence, on demande à la personne de répéter le rendez-vous, l'adresse, ce qu'elle doit apporter	Rappel d'atelier, suivi après une séance, personnes isolées

Exemple – Découper et vérifier une recette de soupe

L'animatrice explique d'abord les trois premières étapes (laver, éplucher, couper) et demande à un binôme de les montrer. Elle passe ensuite à la cuisson (quantité d'eau, durée) et vérifie avec la question « Combien de verres d'eau allez-vous mettre ? ». Elle termine par le mixage et la conservation. Si elle avait tout expliqué d'un bloc, les participants auraient surtout retenu le début et la fin.

Aider les personnes à poser leurs questions : les trois questions clés

Le « faire dire » vérifie ce que la personne a compris. Il faut aussi l'aider à **demander** ce dont elle a besoin : c'est la littératie interactive. Aux États-Unis, la campagne *Ask Me 3* invite les patients à poser trois questions à chaque rencontre avec un professionnel. On peut l'adapter en atelier ou en consultation diététique :

1. « Qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui ? »
2. « Qu'est-ce que je dois faire ? »
3. « Pourquoi est-ce important pour moi ? »

Méthode pas à pas – Introduire les trois questions dans un atelier

1. Afficher les trois questions en gros, avec un pictogramme pour chacune.
2. Les présenter au début : « Vous avez le droit de nous poser ces questions à tout moment. »
3. En fin de séance, inviter chaque binôme à répondre aux trois questions pour lui-même.

4. Remettre une petite carte avec les trois questions à garder pour les rendez-vous médicaux.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.18

Vous appelez Mme R., 79 ans, pour lui rappeler l'atelier de jeudi. Rédigez votre message en découpant l'information, puis la question de « faire dire » que vous lui poserez à la fin de l'appel.

Corrigé

« Bonjour Madame R., c'est Julie, du CCAS. Je vous appelle pour l'atelier cuisine. [Pause] C'est jeudi, à 10 heures. [Pause] C'est à la salle des fêtes, à côté de la mairie. [Pause] Apportez une boîte pour emporter la soupe. » Question finale : « Pour être sûre de ne rien avoir oublié, vous pouvez me redire quel jour vous venez, à quelle heure, et ce que vous apportez ? » Si un élément manque, on le redit autrement (« jeudi, le jour du marché ») puis on vérifie à nouveau.

Ce que disent les études sur le « faire dire »

Le « faire dire » est recommandé par la HAS (2015) et par l'AHRQ. Les études qui l'ont évalué donnent des résultats encourageants, avec des limites qu'il faut connaître pour en parler honnêtement.

Étude	Ce qui a été observé	Limite
Schillinger et coll. (2003), patients diabétiques à littératie limitée	Les médecins vérifiaient rarement la compréhension de leurs patients ; quand ils le faisaient, l'équilibre du diabète des patients était meilleur	Étude d'observation : on ne peut pas affirmer que la vérification est la seule cause
Ha Dinh et coll. (2016), revue systématique chez des personnes avec une maladie chronique	Le « faire dire » améliore la compréhension, l'observance et l'autogestion dans de nombreuses études ; effets moins nets sur les hospitalisations	Études très différentes, souvent courtes et de qualité variable

À retenir – Ce que l'on peut dire au public et aux financeurs

Le « faire dire » est une méthode simple, peu coûteuse et sans effet indésirable connu, qui améliore la compréhension. Ses effets sur la santé à long terme sont moins bien démontrés. On le présente donc comme une bonne pratique de communication, et l'on évalue la compréhension dans ses propres actions.

Calcul détaillé – Mesurer l'effet du « faire dire » dans ses ateliers (données fictives)

Une diététicienne compare deux cycles d'ateliers sur les goûters des enfants. Dans le cycle 1, sans « faire dire », 11 parents sur 25 citent correctement deux goûters adaptés trois semaines plus tard. Dans le cycle 2, avec « faire dire » à chaque séance, 19 parents sur 27 les citent correctement.

- Cycle 1 : 11 / 25 × 100 = **44,0 %** ; cycle 2 : 19 / 27 × 100 = **70,4 %**.
- Différence : 70,4 − 44,0 = **26,4 points**.

Interprétation : le résultat est encourageant, mais les deux groupes ne sont pas les mêmes parents, les effectifs sont petits et d'autres changements ont pu jouer (animatrice plus expérimentée, nouvelle fiche). On parlera d'une amélioration observée, pas d'une preuve d'efficacité.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.19

Un financeur demande : « Le "faire dire" réduit-il les hospitalisations ? » Rédigez une réponse honnête en trois phrases.

Corrigé

« Les études montrent surtout que le "faire dire" améliore la compréhension et la capacité des personnes à appliquer les conseils. Ses effets sur les hospitalisations sont moins nets, car les études sont courtes et très différentes. Dans notre projet, nous mesurerons la compréhension des participants et l'application des conseils à la maison, ce qui est l'objectif de nos ateliers. »

5.3.7 Intégrer la littératie à chaque étape du projet

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Étape (chapitres 7 à 9)	Prise en compte de la littératie
Diagnostic	Recueillir la langue, la lecture, le numérique ; questionnaire oral ou imagé ; entretiens et groupes de parole
Objectifs	Inclure des objectifs de compétences (« savoir lire le Nutri-Score », « savoir cuisiner les lentilles »)
Conception des supports	Appliquer les règles d'écriture claire, FALC, pictogrammes ; tester avant diffusion
Animation	Méthodes actives, démonstrations, faire dire, binômes
Communication	Plusieurs canaux (oral, affiches, bouche-à-oreille, relais) ; ne pas tout miser sur le numérique
Évaluation	Outils d'évaluation accessibles (smileys, gommettes, entretien oral) ; indicateurs de compréhension

Écrire des objectifs de littératie

Un projet qui prend en compte la littératie inclut des **objectifs de compétences**, formulés avec un verbe d'action et vérifiables à la fin d'une séance. La grille de Sørensen aide à les choisir : chaque compétence (accéder, comprendre, évaluer, appliquer) donne une famille de verbes.

Compétence	Verbes utiles	Exemple d'objectif opérationnel
Accéder	Trouver, repérer, demander, contacter	À la fin de la séance, chaque participant sait trouver sur une affiche du marché les fruits et légumes de saison les moins chers
Comprendre	Expliquer, reformuler, montrer, associer	À la fin de l'atelier, 8 participants sur 10 savent expliquer avec leurs mots ce que veut dire la lettre A du Nutri-Score
Évaluer	Comparer, choisir, juger, vérifier	À la fin du cycle, les participants savent comparer deux paquets de céréales et dire lequel contient moins de sucre
Appliquer	Préparer, cuisiner, composer, organiser	Trois semaines après l'atelier, la moitié des participants déclarent avoir cuisiné les lentilles au moins une fois

Attention – Un objectif de littératie n'est pas un objectif de connaissance

« Connaître les repères du PNNS » est difficile à vérifier et ne dit rien de ce que la personne saura faire. On préfère « savoir choisir », « savoir préparer », « savoir demander ». Le verbe « comprendre » seul est trop vague : on le remplace par ce que la personne fera pour montrer qu'elle a compris (« expliquer », « montrer »).

Exemple – De l'objectif général aux objectifs opérationnels

Objectif général : améliorer la littératie alimentaire des familles hébergées au centre. Objectif spécifique : d'ici six mois, les familles savent préparer au moins deux plats complets avec les produits du colis alimentaire. Objectifs opérationnels : organiser six ateliers de cuisine de 2 heures entre janvier et mars ; à chaque atelier, au moins 7 participants sur 10 réussissent le « faire dire » sur la recette du jour.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.20

Transformez ces trois intentions en objectifs de compétences vérifiables : a) « sensibiliser au sucre caché » ; b) « faire connaître l'épicerie solidaire » ; c) « informer sur les dates de consommation ».

Corrigé

a) À la fin de l'atelier, chaque participant sait poser à côté d'une boisson le nombre de morceaux de sucre qu'elle contient. b) À la fin de la réunion, les participants savent dire où se trouve l'épicerie solidaire, quand elle est ouverte et comment y accéder. c) À la fin de l'atelier, les participants savent trier cinq produits entre « à consommer jusqu'au » et « à consommer de préférence avant » et dire ce qu'ils feront de chacun après la date.

Concevoir avec les personnes concernées

Un support conçu **avec** le public est mieux compris et mieux accepté qu'un support conçu **pour** lui. La participation peut prendre plusieurs formes, de la simple relecture à la co-création, et elle s'organise dès le début du projet (chapitre 7).

Forme de participation	Exemple	Ce qu'elle apporte
Relecture et test	Trois mamans relisent la fiche recette et soulignent les mots difficiles	Repère les mots et les images mal compris
Groupe de travail	Des habitants choisissent les recettes et les photos du livret	Supports proches des pratiques réelles
Co-animation	Une habitante relais montre sa recette en atelier	Confiance, valorisation, modèle proche
Comité d'usagers	Des usagers donnent leur avis sur l'affichage des menus d'une cuisine centrale	Amélioration durable de l'organisation

Calcul détaillé – Combien de personnes pour tester un support ?

Le spécialiste de l'ergonomie Jakob Nielsen (2000) a proposé un modèle simple pour les tests d'utilisabilité : si chaque testeur repère en moyenne 31 % des problèmes d'un support, la part des problèmes repérés par n testeurs vaut $1 - (1 - 0{,}31)^n$.

- 1 testeur : 1 − 0,69 = **31,0 %** des problèmes.
- 3 testeurs : 1 − 0,69 × 0,69 × 0,69 = 1 − 0,329 = **67,1 %**.
- 5 testeurs : $1 - 0{,}69^5 = 1 - 0{,}156$ = **84,4 %**.
- 8 testeurs : $1 - 0{,}69^8 = 1 - 0{,}051$ = **94,9 %**.

Interprétation : quelques testeurs bien choisis repèrent déjà la plupart des problèmes ; il vaut mieux faire deux petits tests successifs (cinq personnes, correction, puis cinq autres) qu'un seul grand test. Le chiffre de 31 % est une moyenne observée dans des tests de sites internet : c'est un ordre de grandeur, pas une loi.

Attention – Respecter les personnes qui participent

La participation demande du temps aux habitants. On les informe de l'usage de leur avis, on les remercie publiquement s'ils le souhaitent, on leur montre ce qui a changé grâce à eux et, quand c'est possible, on reconnaît leur travail (bon d'achat, repas partagé, indemnisation prévue dans le budget du projet). On veille aussi à ne pas toujours solliciter les mêmes personnes.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.21

Vous avez fait tester une affiche par 3 personnes. Selon le modèle de Nielsen, quelle part des problèmes avez-vous probablement repérée ? Combien de testeurs supplémentaires proposez-vous, et pourquoi ?

Corrigé

Avec 3 testeurs : $1 - 0{,}69^3 = 1 - 0{,}329 = 67{,}1\ \%$ des problèmes environ. On peut corriger l'affiche, puis la faire tester par 2 à 5 nouvelles personnes : avec 5 testeurs au total, on repère environ 84 % des problèmes, et la seconde série vérifie aussi que les corrections sont comprises. On choisit des testeurs proches du public visé (langue, âge, lecture).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.6 et 5.3.7 – Vérifier et intégrer au projet

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les cinq temps de la boucle du « faire dire ».
2. Qu'est-ce que la technique « découper et vérifier » ?
3. Dans quels cas préfère-t-on « faire faire » plutôt que « faire dire » ?
4. Citez les trois questions clés que l'on peut apprendre aux participants à poser.
5. Transformez « sensibiliser aux étiquettes » en objectif de compétence vérifiable.
6. Selon le modèle de Nielsen, quelle part des problèmes d'un support cinq testeurs repèrent-ils environ ?

Corrigé – Point d'étape 5.3.6 et 5.3.7

1. Expliquer, faire dire, vérifier, réexpliquer autrement si besoin, confirmer.
2. Donner une information à la fois et vérifier qu'elle est comprise avant de passer à la suivante.
3. Pour les gestes techniques, les quantités et les prix (numératie), et avec un public allophone.
4. « Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? », « Qu'est-ce que je dois faire ? », « Pourquoi est-ce important pour moi ? »
5. Par exemple : « À la fin de l'atelier, chaque participant sait comparer deux paquets de biscuits avec le Nutri-Score et dire lequel il choisirait. »
6. Environ 84 % ($1 - 0{,}69^5$).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux des sections 5.3.6 et 5.3.7, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis les deux sections et je refais les exercices d'application.

5.3.8 Lire une étiquette : un savoir-faire de littératie alimentaire

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M3 S1 §2 (p. 29)

L'étiquetage des denrées est encadré par le **règlement (UE) n° 1169/2011** (dit « INCO ») : dénomination, liste des ingrédients, allergènes mis en évidence, quantité nette, dates, conditions de conservation, déclaration

nutritionnelle (énergie, matières grasses, acides gras saturés, glucides, sucres, protéines, sel, pour 100 g ou 100 mL). Le **Nutri-Score**, logo facultatif en France depuis 2017, complète cette information ; son algorithme a été révisé (aliments en 2022, boissons en 2023) et rendu applicable en France par l'arrêté du 14 mars 2025, avec deux ans de transition pour les produits déjà sur le marché.

Figure 5.7 – Lire une étiquette en 6 étapes

Comprendre le schéma – Figure 5.7

1. La dénomination dit ce qu'est réellement le produit ; « préparation à base de… », « saveur… » signalent souvent une faible part de l'ingrédient mis en avant sur l'emballage.

2. La liste d'ingrédients est classée par ordre **décroissant** de poids : le premier ingrédient est le plus abondant ; les **14 allergènes** réglementaires apparaissent en gras ou soulignés ; une longue liste avec additifs signale souvent un produit ultra-transformé (chapitre 4).

3. Le Nutri-Score (de A, vert foncé, à E, orange foncé) permet de **comparer** des produits d'une **même famille** (deux céréales, deux pizzas), pas une pizza et une pomme.

4. Le tableau nutritionnel donne les valeurs **pour 100 g** (pour comparer) et parfois **par portion** (pour savoir ce que l'on mange réellement) ; la portion indiquée par le fabricant est souvent plus petite que celle réellement consommée.

5. Les dates : DLC (« à consommer jusqu'au ») et DDM (« à consommer de préférence avant »), chapitre 4.

6. Le prix au kilo, affiché en rayon, permet de comparer des conditionnements différents.

Exemple – Calcul détaillé : du tableau nutritionnel aux morceaux de sucre

Une boisson aux fruits contient **9,8 g de sucres pour 100 mL** ; la bouteille fait **33 cL** ; on retient qu'un morceau de sucre pèse **environ 5 g**.

- Sucres dans la bouteille : 9,8 × 330 / 100 = 9,8 × 3,3 = **32,3 g**.
- En morceaux de sucre : 32,3 / 5 = **6,5 morceaux**.
- Repère : l'OMS recommande de limiter les **sucres libres** à moins de 10 % de l'apport énergétique (idéalement moins de 5 %) ; pour un adulte à 2 000 kcal, 10 % = 200 kcal, soit 200 / 4 = **50 g** de sucres par jour. La bouteille en représente 32,3 / 50 × 100 = **64,6 %**.
- Pour un enfant de 8 ans à environ 1 700 kcal : 10 % = 170 kcal, soit 170 / 4 = **42,5 g** ; la bouteille en

représente 32,3 / 42,5 × 100 = **76 %**.

En atelier, on matérialise : 6 à 7 morceaux de sucre posés à côté de la bouteille ; l'image est mieux comprise que les grammes (littératie numérique et calculatoire).

Exemple – Calcul détaillé : comparer deux produits « pour 100 g » et « par portion »

Pour 100 g	Céréales A (Nutri-Score A)	Céréales B (Nutri-Score D)	Portion habituelle
Énergie	360 kcal	420 kcal	40 g
Sucres	4,5 g	26 g	
Fibres	10 g	3 g	
Prix au kilo	3,20 €	4,90 €	

- Sucres par portion : A : 4,5 × 40 / 100 = **1,8 g** ; B : 26 × 40 / 100 = **10,4 g**, soit plus de 2 morceaux de sucre (10,4 / 5 = 2,1).
- Fibres par portion : A : 10 × 0,4 = **4 g** ; B : 3 × 0,4 = **1,2 g**.
- Coût par portion : A : 0,040 × 3,20 = **0,13 €** ; B : 0,040 × 4,90 = **0,20 €**.

Conclusion : le produit le mieux classé au Nutri-Score est aussi le moins cher par portion ; le message « mieux et moins cher » est particulièrement mobilisateur pour des publics à budget contraint.

Les allégations nutritionnelles : ce que les mots veulent dire

Les mentions comme « riche en fibres » ou « allégé » attirent l'œil sur l'emballage. Elles sont encadrées par le **règlement (CE) n° 1924/2006** sur les allégations nutritionnelles et de santé : chaque mention correspond à un **seuil précis**. Les connaître permet d'expliquer au public ce qu'elles promettent vraiment, et ce qu'elles ne disent pas.

Allégation	Condition (annexe du règlement 1924/2006)
Faible teneur en sucres	5 g de sucres au plus pour 100 g (2,5 g pour 100 mL pour une boisson)
Sans sucres	0,5 g de sucres au plus pour 100 g ou 100 mL
Sans sucres ajoutés	Aucun sucre ni aliment sucrant ajouté ; si le produit contient des sucres naturellement présents, l'étiquette doit l'indiquer
Faible teneur en matières grasses	3 g au plus pour 100 g (1,5 g pour 100 mL)
Pauvre en sel	0,12 g de sodium au plus pour 100 g, soit environ 0,3 g de sel
Source de fibres	3 g de fibres au moins pour 100 g, ou 1,5 g pour 100 kcal
Riche en fibres	6 g au moins pour 100 g, ou 3 g pour 100 kcal
Source de protéines	Les protéines apportent au moins 12 % de l'énergie du produit
Riche en protéines	Au moins 20 % de l'énergie
Allégé, réduit en…	Au moins 30 % de moins qu'un produit similaire (25 % pour le sel)

Attention – Une allégation ne fait pas un aliment favorable

« Allégé en matières grasses » ne veut pas dire « peu calorique » ni « peu sucré » : un produit allégé en gras peut être riche en sucres. « Sans sucres ajoutés » ne veut pas dire « sans sucres » : une compote ou un jus contiennent les sucres des fruits. « Source de fibres » peut figurer sur des biscuits très sucrés. En atelier, on apprend à vérifier l'allégation avec le tableau nutritionnel et à comparer avec le Nutri-Score.

Calcul détaillé – Vérifier trois allégations (produits fictifs)

- Des biscuits affichent « source de fibres » : 4,5 g de fibres et 450 kcal pour 100 g. Le seuil de 3 g pour 100 g est atteint ; pour 100 kcal, ils apportent 4,5 / 450 × 100 = **1,0 g** de fibres, sous le seuil de 1,5 g ; il suffit qu'une des deux conditions soit remplie : l'allégation est **autorisée**, mais les biscuits contiennent aussi 28 g de sucres pour 100 g.
- Des céréales affichent « source de protéines » : 8 g de protéines et 380 kcal pour 100 g. Part de l'énergie : 8 × 4 / 380 × 100 = **8,4 %**, sous le seuil de 12 % : l'allégation serait **non conforme**.
- Un yaourt « allégé » contient 1,6 g de lipides pour 100 g, contre 3,2 g pour le yaourt de référence : baisse de (3,2 − 1,6) / 3,2 × 100 = **50 %** : conforme. Mais il contient 9,5 g de sucres pour 100 g contre 12,5 g pour un yaourt aromatisé classique : la baisse des sucres, (12,5 − 9,5) / 12,5 × 100 = **24 %**, ne suffirait pas pour écrire « réduit en sucres ».

À vous de jouer – Exercice d'application 5.22

Une boisson affiche « faible teneur en sucres » et contient 4 g de sucres pour 100 mL. Un pain de mie affiche « riche en fibres » et contient 5 g de fibres et 250 kcal pour 100 g. Dites si chaque allégation est conforme.

Corrigé

Boisson : le seuil pour un liquide est de 2,5 g pour 100 mL ; avec 4 g, l'allégation n'est pas conforme. Pain de mie : 5 g pour 100 g est sous le seuil de 6 g, mais pour 100 kcal il apporte 5 / 250 × 100 = 2,0 g, sous le seuil de 3 g : l'allégation « riche en fibres » n'est pas conforme ; « source de fibres » le serait (5 g pour 100 g, au-dessus de 3 g).

Les apports de référence de l'étiquette : un repère à expliquer

Beaucoup d'emballages indiquent, à côté du tableau nutritionnel, un pourcentage des **apports de référence** (AR) par portion. Ces valeurs sont fixées par le règlement INCO (annexe XIII) pour un adulte moyen : ce ne sont pas des besoins personnels, mais des repères communs pour comparer.

Élément	Apport de référence (adulte, règlement INCO)
Énergie	8 400 kJ, soit 2 000 kcal
Matières grasses	70 g
Acides gras saturés	20 g
Glucides	260 g
Sucres	90 g
Protéines	50 g
Sel	6 g

Attention – Deux repères de sucres différents

L'AR des **sucres** de l'étiquette (90 g) porte sur **tous** les sucres, y compris ceux du lait et des fruits. Le repère de l'OMS (moins de 10 % de l'énergie, soit environ 50 g pour 2 000 kcal) ne porte que sur les **sucres libres** (ajoutés, miel, sirops, jus). Un pourcentage d'AR faible pour les sucres peut donc rassurer à tort. En atelier, on préfère traduire les sucres en morceaux.

Calcul détaillé – Une demi-pizza en pourcentage des apports de référence (produit fictif)

Pour 100 g : 245 kcal ; lipides 9,5 g ; acides gras saturés 4,2 g ; glucides 29 g ; sucres 3,6 g ; protéines 10,5 g ;

sel 1,3 g. La portion indiquée est une demi-pizza de 200 g.

- Énergie : 245 × 2 = 490 kcal, soit 490 / 2 000 × 100 = **24,5 %** de l'AR.
- Acides gras saturés : 8,4 g, soit 8,4 / 20 × 100 = **42,0 %**.
- Sel : 2,6 g, soit 2,6 / 6 × 100 = **43,3 %**.
- Sucres : 7,2 g, soit **8,0 %** de l'AR.

Interprétation : la demi-pizza apporte un quart de l'énergie de référence de la journée, mais près de la moitié du sel et des graisses saturées. On conseille de l'accompagner d'une grande salade et d'un fruit, et de limiter les autres aliments salés ce jour-là.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.23

Un paquet de chips indique pour une portion de 30 g : 160 kcal et 0,45 g de sel. Calculez le pourcentage des AR pour l'énergie et pour le sel. Que se passe-t-il si une personne mange le sachet entier de 150 g ?

Corrigé

Portion : énergie 160 / 2 000 × 100 = 8,0 % ; sel 0,45 / 6 × 100 = 7,5 %. Le sachet de 150 g contient 150 / 30 = 5 portions : 5 × 160 = 800 kcal, soit 40,0 % de l'AR, et 5 × 0,45 = 2,25 g de sel, soit 37,5 % de l'AR. La portion indiquée est petite : les pourcentages par portion peuvent sous-estimer ce qui est réellement mangé.

Comment le Nutri-Score est-il calculé ?

Le Nutri-Score a été proposé par l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle de Serge Hercberg et adopté en France par un arrêté du 31 octobre 2017, comme logo facultatif. Il est aussi utilisé en Belgique, en Espagne, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse. Son calcul se fait en trois temps, pour 100 g ou 100 mL de produit.

Méthode pas à pas – Le principe du calcul (sans les tableaux de points)

1. Points défavorables : on attribue des points selon la teneur en énergie, en sucres, en acides gras saturés et en sel ; plus il y en a, plus il y a de points.

2. Points favorables : on attribue des points selon la teneur en fibres, en protéines et la part de fruits, légumes et légumineuses.

3. Score final : points défavorables moins points favorables ; le score est ensuite converti en une lettre de A à E, avec des seuils différents pour les aliments solides, les boissons et les matières grasses.

Ce qui a changé avec l'algorithme révisé (aliments 2022, boissons 2023)	Conséquence pour le consommateur
Les sucres et le sel sont pénalisés plus fortement	Des céréales sucrées et des produits salés perdent une lettre
Les céréales complètes sont mieux distinguées des céréales raffinées	Le pain et les pâtes complets sont mieux classés
Les huiles d'olive, de colza et de noix sont mieux classées	Elles peuvent obtenir la lettre B
La viande rouge est moins bien classée que la volaille et le poisson	Les plats à base de viande rouge baissent
Les boissons : l'eau est la référence, les boissons avec édulcorants sont pénalisées, les boissons lactées sucrées sont classées avec les boissons	Les boissons sucrées ou édulcorées sont moins bien classées qu'avant ; seule l'eau obtient la lettre A

Exemple – Expliquer un « changement de lettre » au public

Une participante s'étonne : « Mes céréales étaient B, maintenant elles sont D. Elles ont changé ? » Réponse simple : « La recette n'a peut-être pas changé. C'est la règle de calcul qui a changé : elle compte plus le sucre. Vos céréales contiennent beaucoup de sucre, c'est pour ça qu'elles ont perdu des lettres. Comparez-les avec un autre paquet de céréales du même rayon. »

À vous de jouer – Exercice d'application 5.24

Expliquez en deux phrases simples, pour un atelier, pourquoi on ne peut pas comparer le Nutri-Score d'un soda et celui d'un fromage.

Corrigé

« Le Nutri-Score compare des produits qui se ressemblent : deux fromages entre eux, ou deux boissons entre elles. Un fromage et un soda ne servent pas à la même chose et ne sont pas calculés de la même façon. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.8 – Lire une étiquette

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans quel ordre sont classés les ingrédients d'une liste ? Comment repère-t-on les allergènes ?
2. Quelle différence y a-t-il entre DLC et DDM ?
3. Quel est le seuil de l'allégation « faible teneur en sucres » pour un aliment solide ?
4. Un produit de 400 kcal pour 100 g contient 10 g de protéines. Peut-il afficher « source de protéines » ?
5. Pourquoi l'apport de référence des sucres de l'étiquette (90 g) ne se compare-t-il pas au repère de l'OMS ?
6. Citez les deux familles de composants qui entrent dans le calcul du Nutri-Score.

Corrigé – Point d'étape 5.3.8

1. Par ordre décroissant de poids ; les 14 allergènes réglementaires sont mis en évidence (gras, souligné).
2. DLC (« à consommer jusqu'au ») : ne pas dépasser ; DDM (« de préférence avant ») : le produit reste consommable après la date s'il est bien conservé.
3. 5 g de sucres au plus pour 100 g.
4. 10 × 4 / 400 × 100 = 10 % de l'énergie, sous le seuil de 12 % : non.
5. L'AR porte sur tous les sucres ; le repère de l'OMS porte sur les sucres libres (environ 50 g pour 2 000 kcal).
6. Les composants défavorables (énergie, sucres, acides gras saturés, sel) et favorables (fibres, protéines, fruits, légumes et légumineuses).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je refais les calculs d'allégations et je relis le tableau des apports de référence.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section 5.3.8 et je refais les exercices d'application.

5.3.9 Comprendre et présenter des chiffres : la numératie en santé

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

La **numératie** (*numeracy*) est la capacité à comprendre et utiliser des nombres, des pourcentages, des proportions et des probabilités dans la vie courante. Une part importante de la population a des difficultés avec

les pourcentages et les risques ; or les messages de santé sont pleins de chiffres (« 5 par jour », « 30 minutes », « – 30 % de risque », « 25 g de fibres »).

Présenter un risque de façon compréhensible

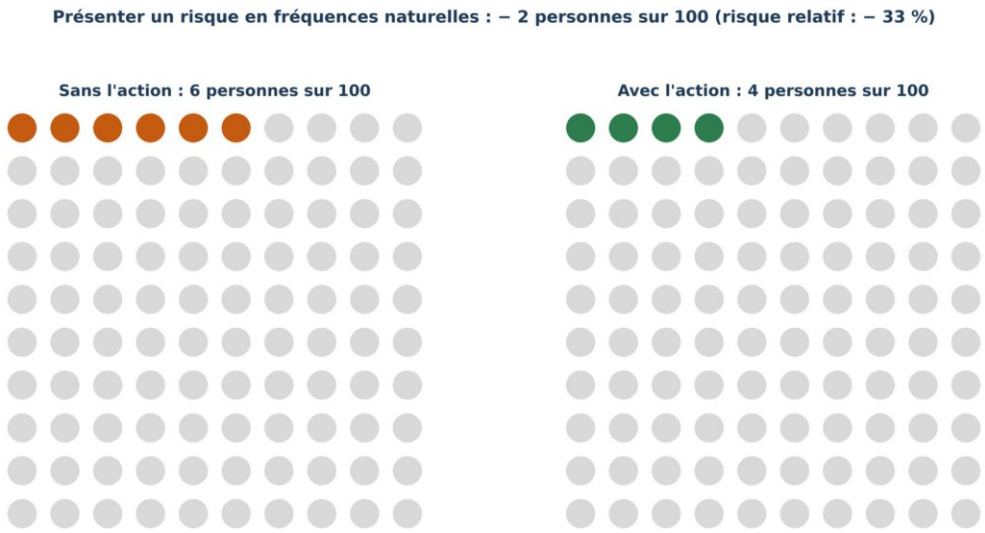


Figure 5.8 – Un risque présenté en fréquences naturelles

Comprendre le schéma – Figure 5.8

1. Les **fréquences naturelles** (« 6 personnes sur 100 ») sont mieux comprises que les pourcentages ou les probabilités (« 0,06 ») (Gigerenzer).
2. Les **tableaux d'icônes** (100 pictogrammes dont certains colorés) rendent visible l'ampleur réelle d'un risque.
3. Passer de 6 à 4 personnes sur 100 correspond à une **réduction absolue** de **2 personnes sur 100** (2 points) mais à une **réduction relative** de (6 − 4) / 6 × 100 = **33 %**.
4. Présenter seulement la réduction relative (« − 33 % ! ») **exagère** l'effet perçu ; la présentation honnête donne les deux, en fréquences naturelles (chapitre 2 : risque relatif et différence de risques).

À éviter	À préférer	Pourquoi
« Réduit le risque de 50 % »	« Le risque passe de 2 sur 100 à 1 sur 100 »	Le relatif seul exagère
« 0,3 % de la population »	« 3 personnes sur 1 000 »	Les petites proportions sont difficiles à se représenter
« 25 g de fibres par jour »	« Du pain complet, des légumes à chaque repas, des légumes secs 2 fois par semaine »	Les grammes de nutriments ne se voient pas dans l'assiette
« 400 g de fruits et légumes »	« 5 portions : une portion = un poing ou deux cuillères à soupe pleines »	Mesure concrète
« 10 % de l'apport énergétique »	« Pas plus d'un verre de jus par jour »	Traduire en aliments

À vous de jouer – Exercice d'application 5.25

Une publicité affirme : « Notre yaourt réduit de 40 % le risque de troubles digestifs ! » L'étude citée montre 5 personnes sur 100 avec troubles dans le groupe témoin et 3 sur 100 dans le groupe yaourt. Calculez les réductions absolue et relative et rédigez une phrase honnête.

Corrigé

Réduction absolue : 5 − 3 = **2 personnes sur 100** (2 points). Réduction relative : 2 / 5 × 100 = **40 %**. Phrase honnête : « Sur 100 personnes, 3 ont eu des troubles digestifs avec ce yaourt au lieu de 5 sans : 2 personnes sur 100 en ont été protégées. » Il faudrait aussi vérifier la qualité de l'étude, sa durée et qui l'a financée (chapitre 6).

Les pièges de calcul les plus fréquents, et comment les éviter

Les messages de nutrition contiennent beaucoup de chiffres. Certaines erreurs reviennent souvent, chez le public mais aussi chez les professionnels. Les connaître permet de les prévenir dans les supports et de les travailler en atelier.

Piège	Exemple	Ce qu'il faut savoir ou dire
Kilojoules et kilocalories	L'étiquette affiche « 1 674 kJ / 400 kcal » ; une personne retient 1 674	1 kcal = 4,184 kJ ; en atelier, on n'utilise que les kcal, ou mieux, des repères en aliments
Centilitres et millilitres	Une canette de 33 cL est lue « 33 mL »	33 cL = 330 mL ; on montre la canette réelle
Pour 100 g et par portion	On compare les sucres pour 100 g d'un produit et par portion d'un autre	On compare toujours sur la même base, de préférence pour 100 g
Pourcentage et points	« Le risque passe de 10 % à 8 % : il baisse de 2 % »	Il baisse de 2 **points** ; la baisse relative est de 20 %
« Deux fois moins »	« Deux fois moins sucré » compris comme « sans sucre »	Deux fois moins = divisé par 2 ; il reste la moitié du sucre
« Jusqu'à 30 % de moins »	La publicité annonce le chiffre maximal	« Jusqu'à » veut dire que certains produits baissent moins, voire pas du tout
Moyenne	« En moyenne, les élèves de la classe mangent 3 fruits par semaine » compris comme « chaque élève »	Une moyenne cache des personnes très au-dessus et très en dessous

Calcul détaillé – Trois conversions utiles en atelier

- Énergie : un plat affiche 2 100 kJ pour une portion ; 2 100 / 4,184 = **502 kcal**, environ un quart des 2 000 kcal de référence.
- Volume : une bouteille de boisson de 1,5 L contient 1 500 mL ; avec 8 g de sucres pour 100 mL, elle contient 8 × 15 = **120 g** de sucres, soit **24 morceaux** de 5 g.
- Points et pourcentage : la part d'enfants qui prennent un petit-déjeuner passe de 70 % à 84 % ; c'est une hausse de **14 points**, soit une hausse relative de 14 / 70 × 100 = **20 %**.

Méthode pas à pas – Présenter un chiffre dans un support grand public

1. Se demander si le chiffre est indispensable ; sinon, le remplacer par un repère concret.

2. Préférer les nombres entiers et arrondis (« environ 6 morceaux de sucre »).

3. Donner une seule unité, connue du public.

4. Comparer à quelque chose de familier (« autant de sucre que dans 3 yaourts aromatisés »).

5. Tester la compréhension du chiffre avec quelques personnes, comme pour le reste du support.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.26

Un article annonce : « La part des adolescents qui boivent des sodas chaque jour est passée de 25 % à 20 %, soit une baisse de 5 %. » Corrigez la phrase et calculez la baisse relative.

Corrigé

La baisse est de 5 points (25 − 20), et non de 5 %. La baisse relative vaut 5 / 25 × 100 = 20 %. Phrase corrigée : « La part des adolescents qui boivent des sodas chaque jour est passée de 25 % à 20 % : c'est 5 points de moins, soit une baisse d'un cinquième. » Pour le grand public : « Avant, 1 adolescent sur 4 buvait des sodas chaque jour ; maintenant, c'est 1 sur 5. »

Mesures ménagères : passer des grammes aux gestes

Un conseil en grammes est difficile à appliquer sans balance. En atelier comme sur les fiches recettes, on traduit les quantités en **mesures ménagères** : cuillère, verre, bol, poignée, main. Les correspondances varient selon l'ustensile, le remplissage et l'aliment ; il faut donc les construire avec les ustensiles réellement utilisés par le public.

Mesure ménagère	Volume approximatif	Repères de poids (approximatifs, à vérifier)
Cuillère à café rase	5 mL	Sucre : environ 5 g ; sel : environ 5 g
Cuillère à soupe rase	15 mL	Huile : environ 10 à 14 g selon le remplissage ; sucre : environ 12 à 15 g
Verre (type verre à eau)	150 à 200 mL	Riz ou lentilles crus : environ 150 à 180 g pour un verre plein
Bol	300 à 350 mL	Soupe : un bol plein
Poing fermé	—	Repère d'une portion de fruits ou de légumes (environ 80 à 100 g)
Paume de la main sans les doigts	—	Repère d'une portion de viande ou de poisson

Méthode pas à pas – Construire sa propre table de correspondance

1. Choisir l'ustensile du public (le verre de la cuisine du centre social, le bol des familles).

2. Remplir l'ustensile trois fois avec l'aliment et peser à chaque fois.

3. Calculer la moyenne et l'arrondir.

4. Écrire la correspondance sur la fiche recette, avec la photo de l'ustensile.

Calcul détaillé – Un verre de riz au centre social (données fictives)

Trois pesées d'un verre de riz cru rempli à ras bord : 162 g, 170 g et 166 g.

- Moyenne : (162 + 170 + 166) / 3 = 498 / 3 = **166 g**.
- Pour une recette qui demande 60 g de riz cru par personne, il faut 60 / 166 = **0,36 verre**, soit **un tiers de verre** environ par personne, ou **un verre pour 3 personnes**.

Sur la fiche : « Riz : 1 verre pour 3 personnes » avec la photo du verre. La consigne est plus facile à suivre que « 180 g de riz pour 3 personnes ».

À vous de jouer – Exercice d'application 5.27

Une recette pour 4 personnes demande 240 g de lentilles corail crues. Au centre social, un verre de lentilles corail pèse en moyenne 180 g. Combien de verres faut-il ? Proposez la formulation pour la fiche.

Corrigé

240 / 180 = 1,33 verre, soit environ un verre et un tiers. Formulation : « Lentilles corail : 1 verre plein et un tiers de verre » avec la photo du verre, ou plus simple : « 1 verre et demi pas tout à fait plein ». On vérifie la formulation en faisant mesurer un participant pendant l'atelier.

Construire un graphique ou un tableau d'icônes que tout le monde comprend

Un graphique peut aider à comprendre, ou au contraire tromper. Quelques règles simples rendent les graphiques plus honnêtes et plus lisibles, que ce soit dans un dossier de projet, un diaporama ou une affiche.

Règle	Pourquoi
Un axe des barres qui commence à zéro	Un axe tronqué grossit les différences
Un seul message par graphique, écrit dans le titre	Le lecteur sait ce qu'il doit voir
Pas d'effet 3D, pas de camembert à plus de 4 parts	Les angles et les volumes sont mal estimés
Les mêmes dénominateurs (« sur 100 », « sur 1 000 ») pour comparer	Comparer 2 sur 100 et 1 sur 50 demande un calcul
Les étiquettes directement sur les barres	Le lecteur ne fait pas d'aller-retour avec une légende
Des couleurs distinctes aussi en noir et blanc	Les personnes daltoniennes et les photocopies

Calcul détaillé – L'effet d'un axe tronqué

Deux quartiers : 42 % et 46 % des enfants prennent un petit-déjeuner chaque jour. La différence réelle est de 4 points, soit (46 − 42) / 42 × 100 = **9,5 %** de plus.

- Axe qui commence à 0 : les barres mesurent 42 et 46 unités ; la seconde est à peine plus haute.
- Axe qui commence à 40 : les barres mesurent 42 − 40 = 2 et 46 − 40 = 6 unités ; la seconde paraît **3 fois** plus haute.

Leçon : on vérifie toujours le début de l'axe avant d'interpréter un graphique, et l'on commence à zéro dans ses propres supports.

Méthode pas à pas – Construire un tableau d'icônes

1. Choisir le dénominateur : 100 icônes pour des risques de quelques pour cent, 1 000 pour des risques plus rares.

2. Ranger les icônes en lignes de 10, et colorer les personnes concernées en bloc, en commençant en haut à gauche.

3. Faire deux tableaux côte à côte (sans action, avec action) avec la même disposition.

4. Écrire sous chaque tableau la phrase en fréquences naturelles (« 6 personnes sur 100 »).

5. Tester la compréhension : « Dans quel groupe y a-t-il le moins de malades ? De combien ? »

À vous de jouer – Exercice d'application 5.28

Un diaporama compare la part d'enfants en surpoids dans deux écoles : 18 % et 21 %. L'axe vertical va de 15 à 22 %. Expliquez ce que le lecteur risque de croire et proposez une correction.

Corrigé

Avec un axe qui commence à 15, les barres mesurent 3 et 6 unités : le lecteur croit que le surpoids est deux

fois plus fréquent dans la seconde école, alors que la différence réelle est de 3 points (environ 17 % de plus). Correction : faire commencer l'axe à 0, écrire les valeurs sur les barres, et présenter la différence en fréquences naturelles (« 18 enfants sur 100 contre 21 sur 100 »).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.9 – La numératie

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce que la numératie ?
2. Un risque passe de 12 sur 100 à 9 sur 100. Donnez la réduction absolue et la réduction relative.
3. Convertissez 1 255 kJ en kcal.
4. Une part passe de 30 % à 36 %. Est-ce une hausse de 6 % ? Justifiez.
5. Comment construire sa propre correspondance entre un verre et un poids d'aliment ?
6. Pourquoi l'axe d'un graphique en barres doit-il commencer à zéro ?

Corrigé – Point d'étape 5.3.9

1. La capacité à comprendre et utiliser des nombres, des pourcentages, des proportions et des probabilités dans la vie courante.
2. Absolue : 3 personnes sur 100 ; relative : 3 / 12 × 100 = 25 %.
3. 1 255 / 4,184 = 300 kcal environ.
4. Non : c'est une hausse de 6 points ; la hausse relative est de 6 / 30 × 100 = 20 %.
5. Remplir trois fois l'ustensile du public, peser, faire la moyenne, l'écrire sur la fiche avec la photo de l'ustensile.
6. Parce qu'un axe tronqué grossit visuellement les différences.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je refais les calculs de la section et je relis le tableau des pièges.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section 5.3.9 et je refais les exercices d'application.

5.3.10 La littératie numérique et l'inclusion numérique en pratique

Module · Guide 2025 : p. 61 ; p. 24-25 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Applications et sites : aider à choisir et à utiliser

Les applications de scan des produits, les sites officiels (*mangerbouger.fr*, *Mon espace santé*), les réseaux sociaux et les outils d'intelligence artificielle font désormais partie de l'environnement alimentaire. Le diététicien peut aider le public à les **utiliser** et à les **évaluer**.

Critère d'évaluation d'une application ou d'un site	Questions
Éditeur et financement	Qui édite l'outil ? Est-il financé par la publicité, par des marques, par un organisme public ?
Fondement scientifique	Sur quoi reposent les notes ou les conseils (Nutri-Score officiel, algorithme propre, avis d'experts) ?
Mise à jour	Les données sont-elles récentes ? Les repères suivis sont-ils ceux en vigueur ?
Protection des données	Quelles données sont collectées ? Consentement, revente, localisation (RGPD, chapitre 6) ?

Critère d'évaluation d'une application ou d'un site	Questions
Accessibilité	Lisible, simple, utilisable par des personnes âgées ou malvoyantes, disponible en plusieurs langues ?
Effets indésirables	Culpabilisation, obsession du comptage (calories, notes), restriction ?

Rendre un support numérique accessible

Les sites des organismes publics doivent respecter le **référentiel général d'amélioration de l'accessibilité** (RGAA), fondé sur les normes internationales **WCAG** (*Web Content Accessibility Guidelines*). Pour un support numérique de projet (page de présentation, vidéo, publication), quelques règles suffisent à améliorer nettement l'accessibilité : contraste suffisant, taille de texte modifiable, **texte alternatif** décrivant les images, vidéos **sous-titrées**, liens explicites (« Télécharger le livret de recettes » plutôt que « cliquez ici »), navigation simple.

Exemple – Calcul détaillé : un mini-audit d'accessibilité d'une page de projet

Une page de présentation d'ateliers est vérifiée avec 12 critères simples (contraste, titres structurés, texte alternatif des 4 images, sous-titres de la vidéo, liens explicites, langue déclarée, taille de police, formulaire accessible, absence d'information uniquement par la couleur, version imprimable, contact téléphonique, FALC).

- Critères respectés : 7 sur 12, soit 7 / 12 × 100 = **58,3 %**.
- Corrections prioritaires (rapides) : textes alternatifs des images, sous-titres de la vidéo, contact téléphonique visible : 3 critères de plus, soit 10 / 12 × 100 = **83,3 %**.

Leçon : une grande partie de l'accessibilité repose sur des gestes simples, à intégrer dès la conception.

Couleurs et contrastes : un calcul simple pour un support lisible

Le contraste entre le texte et le fond est l'un des critères d'accessibilité les plus importants, pour les personnes malvoyantes mais aussi pour tous ceux qui lisent sur un téléphone en plein soleil ou sur une photocopie. Les règles internationales WCAG, reprises par le RGAA, le mesurent par un **ratio de contraste**.

Méthode pas à pas – Calculer un ratio de contraste

1. Trouver la **luminance relative** de chaque couleur (de 0 pour le noir à 1 pour le blanc) avec un outil de vérification du contraste ou un tableau fourni.

2. Ratio = (luminance la plus claire + 0,05) / (luminance la plus foncée + 0,05). Il va de 1 (aucun contraste) à 21 (noir sur blanc).

3. Comparer aux seuils : **4,5** au moins pour un texte courant et **3** pour un grand texte (niveau AA) ; **7** et **4,5** pour le niveau renforcé (AAA).

Calcul détaillé – Quatre couleurs pour une affiche d'atelier

Luminances relatives (calculées selon les WCAG) : blanc 1,0000 ; vert foncé (#2E7D32) 0,1548 ; jaune vif (#FFD600) 0,6935 ; rouge (#D32F2F) 0,1609 ; noir 0,0000.

- Texte vert foncé sur blanc : 1,05 / (0,1548 + 0,05) = 1,05 / 0,2048 = **5,13** : conforme pour un texte courant.
- Texte jaune sur blanc : 1,05 / (0,6935 + 0,05) = 1,05 / 0,7435 = **1,41** : illisible.
- Texte blanc sur fond rouge : 1,05 / (0,1609 + 0,05) = 1,05 / 0,2109 = **4,98** : conforme, de justesse.
- Texte noir sur fond jaune : (0,6935 + 0,05) / (0 + 0,05) = **14,87** : très bon contraste, utile pour un bandeau d'alerte.

Attention – Ne jamais donner une information par la couleur seule

Environ 8 % des hommes et 0,5 % des femmes d'origine européenne ont une forme de daltonisme, le plus souvent une difficulté à distinguer le rouge et le vert. Un code « vert = conseillé, rouge = à limiter » n'est pas compris par ces personnes. On double toujours la couleur par un mot, une forme ou un pictogramme (pouce levé, sablier), comme le fait le Nutri-Score avec ses lettres.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.29

Un menu de cantine indique les plats végétariens en vert clair sur fond blanc, avec un ratio de contraste de 1,9. Dites ce qui ne va pas et proposez deux corrections.

Corrigé

Le ratio de 1,9 est très inférieur au seuil de 4,5 : le texte est difficile à lire, en particulier pour les personnes malvoyantes. De plus, l'information est donnée seulement par la couleur, ce qui exclut les personnes daltoniennes. Corrections : écrire le texte en noir ou en vert très foncé (par exemple #1B5E20, ratio de 7,87 sur blanc) ; ajouter un pictogramme « feuille » et le mot « végétarien » à côté des plats concernés.

Aider un groupe face aux fausses informations sur l'alimentation

Les réseaux sociaux diffusent chaque jour des conseils alimentaires faux ou exagérés : « détox », régimes miracles, peur des conserves ou du pain. Pendant la pandémie de Covid-19, l'OMS a parlé d'**infodémie** (2020) pour désigner cette surabondance d'informations, vraies et fausses, qui rend difficile de trouver des sources fiables. La littératie critique aide à y faire face. Le professionnel a deux rôles : répondre aux idées fausses sans les renforcer, et entraîner le public à juger lui-même une information (grille des 6 questions, 5.4.1).

Méthode pas à pas – Répondre à une idée fausse : le « sandwich de vérité »

1. Commencer par le fait juste, en une phrase simple : « Les légumes en conserve gardent l'essentiel de leurs fibres et de leurs minéraux. »

2. Nommer l'idée fausse une seule fois, en disant qu'elle est fausse : « On lit parfois que les conserves sont "du poison" : c'est faux. »

3. Expliquer pourquoi elle circule : « Cette idée vient souvent de la peur des produits industriels, ou de vidéos qui vendent autre chose. »

4. Redire le fait juste et donner une action : « Les conserves de légumes et de légumes secs sont pratiques et pas chères. Rincez-les pour enlever une partie du sel. »

À retenir – Ce qui aide, ce qui ne marche pas

Ce qui aide : partir des questions du groupe, rester respectueux, montrer comment on vérifie une source, donner une alternative concrète. Ce qui ne marche pas : se moquer, accumuler les chiffres, répéter l'idée fausse dans le titre d'une affiche (« Les conserves, un poison ? ») : on risque de la rendre plus familière et donc plus crédible.

Exemple – Un atelier « vrai ou faux » avec des collégiens

L'animatrice projette trois publications réelles et anonymisées : une recette « détox » au citron, une vidéo qui dit que le pain fait grossir, et une publication de mangerbouger.fr. Par groupes, les élèves répondent aux questions : qui parle ? que veut-il ? sur quoi s'appuie-t-il ? que disent les sources officielles ? Chaque groupe présente sa conclusion. L'animatrice termine par un « sandwich de vérité » sur le pain.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.30

Une participante dit : « J'ai vu sur internet que les jus détox nettoient le foie. » Rédigez votre réponse en suivant les quatre étapes du sandwich de vérité.

Corrigé

1. « Le foie et les reins éliminent eux-mêmes les déchets du corps, chaque jour. » 2. « On lit souvent que des jus "détox" nettoient le foie : ce n'est pas démontré. » 3. « Ces messages circulent beaucoup parce qu'ils promettent un résultat rapide, et souvent pour vendre des produits. » 4. « Pour aider votre corps, buvez de l'eau et mangez des fruits et des légumes entiers : ils apportent aussi des fibres. »

Accompagner vers le numérique sans exclure

La dématérialisation touche aussi l'alimentation et la santé : inscription aux ateliers, prise de rendez-vous, Mon espace santé (ouvert à tous les assurés en 2022), aides sociales en ligne. Pour les personnes éloignées du numérique, plusieurs dispositifs publics existent. Le diététicien peut s'appuyer sur eux comme **partenaires** d'un projet.

Dispositif	Ce qu'il propose	Intérêt pour un projet en nutrition
Espaces France Services	Accueil de proximité pour les démarches administratives, avec un accompagnement au numérique	Aide à l'inscription en ligne, aux démarches CAF et cantine
Conseillers numériques (dispositif lancé en 2021)	Ateliers d'initiation et accompagnement individuel au numérique, dans les mairies, médiathèques, associations	Ateliers « mon téléphone pour cuisiner » : vidéos de recettes, applications utiles
Aidants Connect	Permet à un professionnel habilité (travailleur social, agent France Services) de faire une démarche en ligne pour le compte d'une personne, de façon sécurisée et avec son accord	Évite que la personne donne ses identifiants à un tiers
Médiathèques, associations d'éducation populaire	Accès libre à des ordinateurs, ateliers	Lieux relais pour diffuser un programme

Méthode pas à pas – Proposer un support numérique dans un projet, sans exclure

1. Toujours prévoir un canal non numérique équivalent (papier, téléphone, accueil).

2. Choisir des formats peu exigeants : message vocal, vidéo courte sous-titrée, photo.

3. Montrer en atelier comment accéder au support (scanner un code, ouvrir une vidéo).

4. Ne jamais demander de créer un compte ou de donner une adresse mail pour participer.

5. Évaluer l'usage réel du support numérique (nombre de vues, avis des participants).

Attention – Les identifiants des personnes

Il arrive qu'un professionnel ou un bénévole remplisse une démarche en ligne avec les identifiants d'une personne. C'est risqué pour la personne et pour le professionnel (accès à des données personnelles, responsabilité). On oriente vers un dispositif prévu pour cela, comme Aidants Connect, ou l'on accompagne la personne pour qu'elle fasse elle-même la démarche.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.31

Un CCAS veut remplacer les inscriptions papier aux ateliers par un formulaire en ligne. Proposez trois conditions pour que ce changement n'exclue personne.

Corrigé

Garder une inscription par téléphone et à l'accueil ; proposer un accompagnement pour remplir le formulaire (agent d'accueil, conseiller numérique, France Services) ; rendre le formulaire court et accessible (peu de champs, pas de compte à créer, texte lisible, contact visible). On suit ensuite la part des inscriptions faites par chaque canal pour vérifier que les publics habituels continuent de s'inscrire.

5.3.11 Communiquer avec des personnes allophones

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Une personne **allophone** est une personne dont la langue maternelle n'est pas la langue du pays où elle vit. Dans de nombreux quartiers, une part importante des familles maîtrise peu le français, au moins à l'écrit.

Ressource	Usage
Interprétariat professionnel (sur place ou par téléphone)	Échanges importants ou sensibles (santé, allergies) ; neutralité et confidentialité garanties ; référentiel de la HAS (2017)
Médiateurs en santé, habitants relais	Lien de confiance, compréhension des codes culturels ; ne remplacent pas un interprète pour une consultation
Supports multilingues testés	Fiches traduites par des professionnels et relues par des locuteurs ; préférer les ressources validées (Santé publique France, associations spécialisées)
Pictogrammes et photos	Recettes en images, gestes d'hygiène, allergènes ; vérifier qu'ils sont compris (certains symboles sont culturels)
Démonstration	Montrer avant d'expliquer ; faire faire
Cours de français à visée sociale	Partenariat avec les associations d'apprentissage du français : les ateliers culinaires peuvent être support d'apprentissage de la langue

Attention – Les enfants interprètes

Faire traduire des informations de santé par un enfant est à éviter : cela inverse les rôles familiaux, expose l'enfant à des informations qui ne le concernent pas et produit des erreurs de traduction. On recherche un interprète professionnel ou un adulte relais.

Travailler avec un interprète : avant, pendant, après

L'interprétariat professionnel fait l'objet d'un référentiel de la HAS (2017). Il peut se faire sur place ou par téléphone, ce qui le rend accessible même pour un atelier ou un entretien court. Un interprète professionnel traduit fidèlement, reste neutre et respecte le secret. Pour que l'échange se passe bien, le professionnel a lui aussi un rôle à jouer.

Moment	Ce que fait le professionnel
Avant	Réserver l'interprète à l'avance et vérifier la langue (et la variante régionale) ; présenter brièvement l'objectif de l'entretien ou de l'atelier et les mots techniques qui seront utilisés ; prévoir plus de temps (environ le double)

Moment	Ce que fait le professionnel
Au début	Présenter l'interprète et son rôle à la personne ; rappeler que tout sera traduit et que tout restera confidentiel
Pendant	Regarder et s'adresser à la **personne**, pas à l'interprète ; parler à la première personne (« Je vous conseille… ») ; faire des phrases courtes et s'arrêter souvent ; éviter les expressions imagées et l'humour difficile à traduire ; vérifier la compréhension avec le « faire dire »
Après	Faire un court bilan avec l'interprète (difficultés de traduction, malentendus culturels possibles) ; noter les mots qui ont posé problème pour les prochaines fois

Exemple – Une phrase difficile à traduire

La diététicienne dit : « Il faut y aller mollo sur le gras et ne pas avoir la main lourde sur le sel. » L'interprète doit d'abord deviner le sens de deux expressions familières avant de les traduire. Reformulation : « Mettez moins d'huile dans la poêle : une cuillère suffit. Mettez moins de sel : goûtez avant de saler. » Les deux phrases sont courtes, concrètes et se traduisent sans perte.

Attention – Médiateur, interprète, accompagnant : trois rôles différents

L'**interprète** traduit fidèlement et reste neutre. Le **médiateur en santé** crée le lien de confiance, explique les codes et accompagne vers les droits et les soins ; il peut traduire de façon informelle, mais ce n'est pas son rôle principal. Le **proche accompagnant** connaît la personne mais peut filtrer ou déformer l'information, volontairement ou non. Pour une information médicale importante (allergie, traitement, régime prescrit), on fait appel à un interprète professionnel.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.32

Pendant un entretien avec interprète, une diététicienne dit à l'interprète : « Demandez-lui ce qu'elle mange le matin. » Relevez l'erreur, réécrivez la phrase, et citez deux autres règles à respecter pendant l'échange.

Corrigé

Elle parle à l'interprète et de la personne à la troisième personne, ce qui exclut la personne de l'échange. Réécriture, en regardant la personne : « Qu'est-ce que vous mangez le matin ? » Autres règles : faire des phrases courtes et s'arrêter pour laisser traduire ; éviter les expressions imagées ; vérifier la compréhension par le « faire dire » à la fin.

Des ressources multilingues et visuelles à connaître

Il est rarement utile de tout créer soi-même. Des ressources existent, conçues par des institutions ou des associations, souvent testées auprès des publics. Avant de les utiliser, on vérifie la date, la source et l'adaptation au public, comme pour tout outil pédagogique (5.3.13).

Ressource	Ce qu'elle propose	Point de vigilance
Livret de santé bilingue (Comede et Santé publique France)	Informations sur le système de santé et la prévention, en français et dans une autre langue, dans de nombreuses langues	Vérifier la dernière mise à jour et la présence de la langue souhaitée
Supports de Santé publique France et du PNNS	Affiches et dépliants sur les repères alimentaires, parfois en plusieurs langues ou en version adaptée	Repères de 2019 pour les adultes : vérifier la version

Ressource	Ce qu'elle propose	Point de vigilance
SantéBD	Bandes dessinées en FALC pour comprendre la santé, les consultations et certains examens	Conçu pour le handicap intellectuel, utile pour d'autres publics
Banques de pictogrammes libres de droits	Pictogrammes pour les recettes, les allergènes, les consignes	Tester la compréhension auprès du public (5.3.5)
Associations d'apprentissage du français et de médiation	Mots de vocabulaire alimentaire illustrés, ateliers de langue autour de la cuisine	Construire le partenariat en amont

Méthode pas à pas – Faire traduire un support écrit de santé

1. Simplifier d'abord le texte en français : un texte clair se traduit mieux.

2. Confier la traduction à un traducteur professionnel ou à un service spécialisé ; un outil de traduction automatique peut servir de brouillon, jamais de version finale.

3. Faire relire la traduction par une ou deux personnes dont c'est la langue, si possible du public visé.

4. Vérifier les images : certaines photos ou certains aliments peuvent ne rien évoquer ou choquer.

5. Tester le support traduit comme la version française, puis noter la date et la source sur le document.

Calcul détaillé – Choisir les langues à traduire (données fictives)

Dans une maison de quartier, le diagnostic oral auprès de 90 familles donne les langues parlées à la maison : arabe 28, turc 17, tamoul 9, roumain 7, autres langues (moins de 4 familles chacune) 11, français seulement 18.

- Familles qui parlent une autre langue que le français : 90 − 18 = **72**, soit 72 / 90 × 100 = **80,0 %**.
- Les trois premières langues réunissent 28 + 17 + 9 = **54** familles, soit 54 / 72 × 100 = **75,0 %** des familles qui parlent une autre langue.

Décision : traduire les supports clés en arabe, en turc et en tamoul ; pour les autres familles, s'appuyer sur les images, la démonstration et l'interprétariat par téléphone pour les entretiens importants.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.33

Une collègue a traduit la fiche « goûters » en roumain avec un traducteur automatique et veut l'imprimer à 200 exemplaires. Citez deux risques et décrivez ce que vous proposez avant l'impression.

Corrigé

Risques : erreurs de sens (mots de cuisine, quantités, allergènes) qui peuvent être dangereuses ; phrases incompréhensibles qui décrédibilisent la structure. Proposition : simplifier le texte français, faire relire ou traduire par une personne compétente dont c'est la langue, tester la fiche auprès de deux ou trois familles roumanophones, puis imprimer un petit nombre d'exemplaires.

Une adaptation pour chaque situation

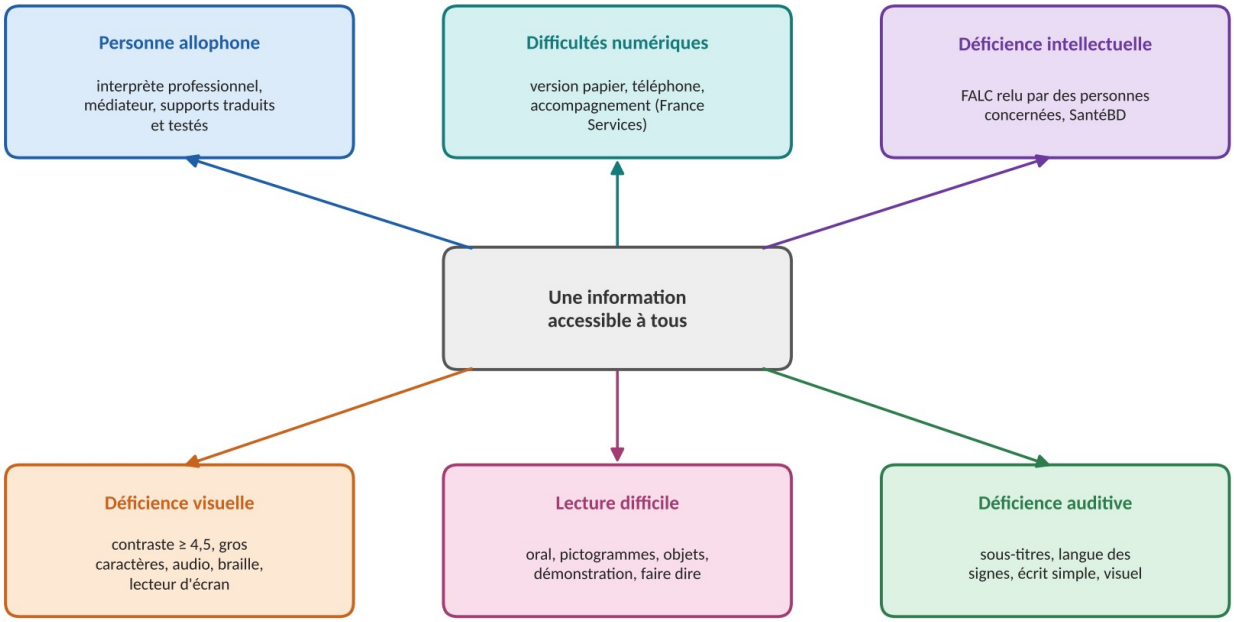


Figure 5.8 bis – Adapter l'information selon la situation de la personne

Comprendre le schéma – Figure 5.8 bis

1. Au centre, l'objectif commun : une information **accessible à tous**. Les six cases montrent des situations fréquentes, qui peuvent se cumuler chez une même personne.
2. **Langue** et **numérique** (en haut) relèvent surtout de l'organisation : interprète, médiateur, version papier, téléphone, accompagnement France Services.
3. **Déficiences** intellectuelle, visuelle et auditive : chacune appelle des adaptations précises (FALC, contraste et audio, sous-titres et langue des signes), qui se préparent avec les associations concernées.
4. **Lecture difficile** : l'oral, les objets, la démonstration et le faire dire, qui profitent à tous les publics.
5. Beaucoup d'adaptations sont utiles à plusieurs situations à la fois : une vidéo sous-titrée avec un commentaire audio aide les personnes sourdes, malvoyantes, allophones et celles qui lisent peu.

Situation	Adaptations à prévoir pour un atelier cuisine
Déficience visuelle	Accueil oral et description des lieux ; recette en gros caractères ou en audio ; ustensiles toujours rangés au même endroit ; repères tactiles (élastique sur un flacon) ; décrire ce que l'on fait pendant la démonstration
Déficience auditive	Interprète en langue des signes française ou codeur en langue française parlée complétée selon les personnes ; animatrice face au groupe, visage éclairé ; bruit réduit ; consignes écrites et visuelles ; boucle magnétique si disponible
Déficience intellectuelle	Supports en FALC, une étape à la fois, routines stables, durée courte, valorisation, aide d'un éducateur connu
Handicap moteur	Plan de travail à hauteur adaptée, ustensiles ergonomiques, circulation libre, toilettes accessibles
Troubles psychiques	Cadre rassurant, petit groupe, possibilité de faire une pause, pas d'obligation de parler

À vous de jouer – Exercice d'application 5.34

Un groupe d'atelier comprend une personne malvoyante et une personne qui parle peu le français. Proposez

trois adaptations qui aident les deux à la fois.

Corrigé

Décrire à voix haute chaque geste pendant la démonstration, avec des mots simples et des phrases courtes ; faire toucher et sentir les aliments et les ustensiles avant de commencer ; proposer une recette en audio (message vocal) avec des étapes numérotées ; travailler en binôme avec un participant qui guide. Ces adaptations s'appuient sur l'oral, le toucher et la démonstration plutôt que sur l'écrit.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.10 et 5.3.11 – Numérique et langues

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel ratio de contraste minimal faut-il pour un texte courant (niveau AA) ?
2. Pourquoi ne faut-il jamais donner une information par la couleur seule ?
3. Citez les quatre étapes du « sandwich de vérité ».
4. Citez deux dispositifs publics d'accompagnement au numérique.
5. Citez deux règles à respecter pendant un entretien avec un interprète.
6. Pourquoi ne pas imprimer directement un support traduit automatiquement ?

Corrigé – Point d'étape 5.3.10 et 5.3.11

1. 4,5 (et 3 pour un grand texte).
2. Parce que les personnes daltoniennes (environ 8 % des hommes) et les photocopies en noir et blanc ne distinguent pas les couleurs.
3. Dire le fait juste, nommer l'idée fausse une fois en disant qu'elle est fausse, expliquer pourquoi elle circule, redire le fait juste avec une action.
4. Espaces France Services, conseillers numériques, Aidants Connect.
5. S'adresser à la personne et non à l'interprète, parler à la première personne, faire des phrases courtes, éviter les expressions imagées.
6. La traduction peut contenir des erreurs de sens dangereuses ; il faut la faire relire par une personne compétente et la tester.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les méthodes des deux sections et je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis les sections 5.3.10 et 5.3.11 et je refais les exercices d'application.

5.3.12 Concevoir et tester un support accessible : un exemple complet

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Exemple – Avant et après : la fiche « Bien conserver les aliments » d'une épicerie solidaire

Version initiale : texte de 260 mots en 9 phrases, police de 10 points, justifié, trois sigles (DLC, DDM, HACCP), aucune image ; 520 syllabes.

- Indice de lisibilité : mots par phrase 260 / 9 = **28,9** ; syllabes par mot 520 / 260 = **2,0** ; L = 207 − 1,015 × 28,9 − 73,6 × 2,0 = 207 − 29,33 − 147,2 = **30,47** : texte difficile, à la limite du « très difficile ».

Version réécrite : 110 mots en 16 phrases courtes, 160 syllabes ; 6 pictogrammes (réfrigérateur,

thermomètre, calendrier, poubelle barrée…) ; police de 14 points ; un seul message par encadré.

- L = 207 − 1,015 × (110 / 16) − 73,6 × (160 / 110) = 207 − 1,015 × 6,875 − 73,6 × 1,4545 = 207 − 6,98 − 107,05 = **92,97** : très facile.

Test auprès de 8 bénéficiaires : question « Où rangez-vous la viande dans le réfrigérateur ? » (bonne réponse : en haut ou dans la zone la plus froide, selon le modèle) : version initiale 3 bonnes réponses sur 8 (**37,5** %) ; version réécrite 7 sur 8 (**87,5 %**). Question « Peut-on manger un yaourt après la date ? » (réponse attendue : non si DLC) : 2 / 8 (**25 %**) puis 6 / 8 (**75 %**). **Conclusion** : l'indice de lisibilité confirme l'amélioration, mais c'est le **test auprès du public** qui prouve la compréhension.

Tester un support par l'entretien cognitif

Le test d'un support (5.3.12) peut se limiter à une ou deux questions. Pour un support important (livret, affiche d'une campagne, questionnaire de diagnostic), on utilise une méthode plus complète : l'**entretien cognitif**. Issue de la recherche sur les questionnaires (Willis, 2005), elle consiste à demander à quelques personnes du public de lire ou d'utiliser le support **à voix haute**, puis à leur poser des questions précises sur ce qu'elles ont compris.

Méthode pas à pas – Conduire un entretien cognitif de 20 minutes

1. Préparer : choisir 5 à 8 personnes proches du public (langue, âge, lecture), un lieu calme, une grille de questions ; expliquer que l'on teste le document, pas la personne.

2. Penser à voix haute : « Lisez ce document comme chez vous, et dites tout ce qui vous passe par la tête. » On n'aide pas, on note les hésitations.

3. Questions de relance : « Que veut dire ce mot pour vous ? » ; « Avec vos mots, que vous demande-t-on de faire ? » ; « Qu'est-ce qui vous a gêné ? » ; « Que représente cette image ? »

4. Tâche pratique : « Montrez-moi la quantité de riz pour 4 personnes », « Où appelez-vous pour vous inscrire ? »

5. Remercier et noter dans un tableau : problème repéré, nombre de personnes concernées, correction proposée.

Calcul détaillé – Le tableau de synthèse d'un test (livret de recettes, 6 testeuses, données fictives)

Problème repéré	Personnes concernées	Part	Décision
« Émincer » non compris	5 sur 6	83,3 %	Remplacer par « couper en fines lamelles » + photo
Photo de l'étape 3 confondue avec l'étape 4	3 sur 6	50,0 %	Refaire la photo en gros plan
Quantité « 1 verre » : quel verre ?	4 sur 6	66,7 %	Ajouter la photo du verre de référence
Numéro de téléphone trop petit	1 sur 6	16,7 %	Agrandir (correction simple, gardée même si une seule personne l'a signalée)

Règle de décision : on corrige tous les problèmes qui empêchent de comprendre ou d'agir, quel que soit le nombre de personnes ; on discute en équipe des remarques de goût (couleurs, style).

Attention – Ce que l'entretien cognitif ne dit pas

Il montre si le support est compris, pas s'il fera changer les pratiques. Il porte sur quelques personnes, choisies, souvent plus motivées que la moyenne. Il complète l'indice de lisibilité et ne remplace pas l'évaluation de l'action.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.35

Rédigez quatre questions de relance pour tester une affiche qui annonce un atelier « goûters » pour des parents d'une école maternelle.

Corrigé

« Avec vos mots, qu'est-ce que l'affiche vous propose ? » ; « Quel jour et à quelle heure est l'atelier ? Où ? » ; « Que veut dire, pour vous, le mot "goûter équilibré" ? » ; « Que représente la photo en bas à droite ? » On peut ajouter une tâche : « Montrez-moi comment vous feriez pour vous inscrire. »

5.3.13 Choisir et concevoir des outils pédagogiques accessibles

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Les **outils pédagogiques** (jeux, cartes, photos, maquettes, vidéos) rendent les notions concrètes et favorisent la participation, surtout auprès des publics à littératie limitée. Les instances régionales d'éducation et de promotion de la santé mettent à disposition des **pédagothèques** (prêt d'outils) et des bases documentaires qui en présentent l'analyse.

Type d'outil	Exemples en nutrition	Intérêt pour la littératie
Objets réels	Emballages vides, aliments, ustensiles, verres doseurs, morceaux de sucre	Concrets, compréhensibles sans lecture
Photos et photolangage	Photos de plats, de portions, de situations de repas	Expression sans écrit, représentations
Maquettes et répliques d'aliments	Répliques de portions (féculents, viande, fromage)	Estimer les quantités (numératie)
Jeux de cartes et de plateau	Classer des aliments, composer un menu à petit prix	Apprentissage actif, coopération
Outils numériques	Vidéos courtes sous-titrées, quiz sur tablette	Attractifs, à accompagner (illectronisme)
Supports à emporter	Fiches recettes en photos, calendrier des légumes secs, aimant « repères »	Rappel à la maison

Méthode pas à pas – Analyser un outil pédagogique avant de l'utiliser : 8 questions

1. **Qui l'a conçu**, quand, avec quelles sources ? (institution, association, marque ?)
2. Le **contenu** est-il exact et à jour (repères de 2019, PNNS 5) ?
3. Les **objectifs** de l'outil correspondent-ils aux miens ?
4. Le **public** visé (âge, langue, littératie) correspond-il au mien ?
5. L'outil favorise-t-il la **participation** ou seulement l'écoute ?
6. Est-il **non stigmatisant** (images de corps, vocabulaire moral) ?
7. Est-il **accessible** (images, peu d'écrit, manipulation simple) ?
8. Quelles **adaptations** sont nécessaires (traduction, simplification, prix locaux) ?

Exemple – Concevoir un jeu « le panier à 10 € » (littératie alimentaire et numératie)

Objectif : composer, en groupe, les repas d'une journée pour 4 personnes avec 10 €. **Matériel** : 30 cartes-aliments avec photo, nom, portion et **prix par portion** (par exemple lentilles 0,16 € ; œufs 0,28 € l'unité ; poulet 0,75 € ; yaourt 0,18 € ; pomme 0,30 € ; pain complet 0,10 € la tranche). **Déroulé** : chaque équipe compose 3 repas et un goûter, additionne les prix, vérifie la présence des familles d'aliments (code couleur),

présente son panier. **Exemple de calcul** d'un déjeuner pour 4 : lentilles 4 × 0,16 = 0,64 € ; riz 4 × 0,14 = 0,56 € ; carottes 4 × 0,19 = 0,76 € ; yaourts 4 × 0,18 = 0,72 € ; pommes 4 × 0,30 = 1,20 € ; total **3,88 €**, soit 0,97 € par personne. **Intérêt** : manipuler des prix réels, comparer, discuter, sans lecture complexe.

Le photolangage : faire parler sans écrire

Le **photolangage** est une méthode d'animation née à Lyon à la fin des années 1960, dans la formation des adultes. On étale sur une table une série de photos variées ; chaque participant choisit une ou deux photos qui répondent à une question, puis explique son choix au groupe. Il se distingue de l'image d'illustration : la photo n'est pas là pour montrer la « bonne réponse », mais pour **aider à parler** de ses représentations et de son expérience. C'est un outil précieux avec les publics qui lisent peu ou qui parlent peu le français.

Méthode pas à pas – Animer un photolangage en 30 minutes

1. Préparer la question : ouverte et liée à l'objectif (« Choisissez une photo qui représente pour vous un bon repas en famille »).

2. Choisir 30 à 50 photos variées : plats de différentes cultures, situations de repas (seul, en famille, devant un écran), lieux d'achat, personnes de tous âges et de toutes corpulences ; éviter les photos publicitaires et les images qui jugent.

3. Temps de choix silencieux (5 minutes) : chacun regarde et choisit, sans parler.

4. Tour de parole (20 minutes) : chacun montre sa photo et dit pourquoi ; l'animateur reformule, ne juge pas, ne corrige pas.

5. Synthèse (5 minutes) : l'animateur relève les points communs et les différences, qui serviront de point de départ à l'atelier.

Exemple – Ce que le photolangage a révélé

Dans un atelier avec des mères de jeunes enfants, la question était : « Choisissez une photo qui montre un goûter pour votre enfant. » Plusieurs mères ont choisi la photo d'une boisson à la fraise et d'un gâteau emballé : « C'est ce qu'il aime, et c'est propre, ça vient du magasin. » D'autres ont choisi la photo d'un pain avec du chocolat : « Chez nous, c'était ça. » L'animatrice a découvert que pour certaines mères, le produit emballé était un signe de **soin** et de **sécurité**. Elle a construit la suite de l'atelier sur cette idée, au lieu de commencer par les « sucres cachés ».

Attention – Respecter les règles du photolangage

Chacun a le droit de ne pas parler ou de passer son tour ; on ne commente pas le choix des autres ; ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe. Les photos de personnes doivent être libres de droits et ne pas présenter de corps comme des modèles ou des contre-modèles.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.36

Vous préparez un photolangage pour un groupe de retraités sur le thème « manger seul ». Rédigez la question posée et citez six photos à prévoir.

Corrigé

Question : « Choisissez une photo qui ressemble à votre repas du soir, ou à celui que vous aimeriez avoir. » Photos : une personne âgée qui mange seule devant la télévision ; un repas partagé au club ; un plateau-repas livré ; une soupe maison ; un marché ; une table dressée avec une nappe et des fleurs ; un sandwich sur

un coin de table ; une cuisine collective. Les photos montrent des situations variées, sans porter de jugement.

5.3.14 Animer un atelier accessible : une séquence type

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Un atelier conçu selon les **précautions universelles** (5.3.4) profite à tous. La séquence suivante, de 2 heures, intègre les principes du chapitre.

Durée	Étape	Adaptations de littératie
10 min	Accueil	Accueil individuel, prénom écrit en grand, consignes de sécurité montrées (pictogrammes, démonstration), interprète ou médiatrice si besoin
10 min	Recueil des pratiques	Photolangage : « Montrez la photo qui ressemble à votre repas d'hier soir » ; aucune lecture nécessaire
15 min	Message principal	Un seul message (« les légumes secs : bons, rassasiants, pas chers »), avec objets réels (sachets, verre doseur, prix) ; chiffres concrets (0,16 € la portion)
15 min	Démonstration	Geste clé montré lentement (rincer, cuire les lentilles corail), puis refait par un participant
40 min	Pratique en binômes	Recette en photos (une action par photo), binômes mixtes (lecteur / non- lecteur, langues), animateur qui circule et reformule
15 min	Dégustation	Vocabulaire sensoriel simple, échelle à smileys
10 min	Faire dire	Chaque binôme montre ou explique une astuce ; l'animateur réexplique autrement si besoin
5 min	Clôture	Fiche recette en photos à emporter, rappel oral de la date suivante (et message vocal la veille)

Exemple – Calcul détaillé : vérifier la compréhension en fin d'atelier

L'animatrice note, pour 10 participants, la réussite de trois « faire dire » : expliquer la cuisson des lentilles corail (8 réussites), estimer le coût d'une portion à 20 centimes près (6 réussites), citer une recette à refaire (10 réussites).

- Taux de réussite : 8 / 10 = **80 %** ; 6 / 10 = **60 %** ; 10 / 10 = **100 %**.
- Moyenne des trois : (80 + 60 + 100) / 3 = 240 / 3 = **80 %**.
- **Ajustement** : l'estimation du coût est la moins réussie (numératie) : à la séance suivante, l'animatrice prévoit des étiquettes de prix par portion déjà calculées et un exercice de comparaison en binôme.

Adapter la séquence type à quelques publics

La séquence type de 2 heures (5.3.14) se modifie selon le public. Les principes restent les mêmes (précautions universelles, démonstration, faire dire), mais la durée, le rythme et les supports changent.

Public	Adaptations principales
Enfants de 6 à 10 ans	Séance d'une heure ; consignes très courtes ; une tâche par enfant (laver, verser, mélanger) ; vocabulaire des sens (« croquant, doux, acide ») ; dégustation avec une échelle à 3 visages ; aucun jugement sur ce que les familles mangent
Adolescents	Partir de leurs pratiques (restauration rapide, boissons énergisantes) ; méthodes actives et défis ; usage du téléphone (photo, vidéo) ; éviter le ton moralisateur ; donner des choix

Public	Adaptations principales
Personnes âgées	Rythme lent, grande police, bonne lumière, sièges ; tenir compte de l'audition et de la vue ; recettes simples à une seule casserole ; lien social au cœur de la séance
Personnes en situation de handicap intellectuel	Séance courte et régulière, même jour et même lieu ; supports FALC, pictogrammes, une étape à la fois ; routines (lavage des mains en chanson) ; présence d'un éducateur connu
Personnes allophones	Démonstration avant explication ; vocabulaire illustré ; interprète pour les consignes de sécurité ; binômes de même langue si possible ; recettes des pays d'origine valorisées

Exemple – La séance d'un ESAT, en 1 h 15 (données fictives)

L'atelier « Salade de pâtes » accueille 8 travailleurs d'un ESAT, le jeudi à 14 h, chaque semaine pendant 6 semaines. Déroulé : accueil et lavage des mains avec la même chanson chaque semaine (10 minutes) ; présentation des ingrédients réels, chacun nomme ou montre un ingrédient (10 minutes) ; démonstration de l'étape du jour (10 minutes) ; préparation en binômes avec la recette en 5 photos (25 minutes) ; dégustation et vote avec gommettes (10 minutes) ; rangement et « faire faire » : chaque binôme montre l'étape qu'il a réussie (10 minutes). Total : 10 + 10 + 10 + 25 + 10 + 10 = **75 minutes**.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.37

Un club de collégiens veut un atelier « petit-déjeuner » d'une heure, de 12 h 30 à 13 h 30. Proposez un déroulé minuté avec deux adaptations propres à ce public.

Corrigé

Exemple : 5 minutes d'accueil ; 10 minutes de défi « le vrai prix du petit-déjeuner » (les élèves classent par prix des produits réels et des photos de petits-déjeuners) ; 10 minutes de démonstration d'un petit-déjeuner rapide (pain, fromage, fruit, boisson) ; 20 minutes de préparation en équipes, chacune invente sa version ; 10 minutes de dégustation et de photos ; 5 minutes de « faire dire » : chaque équipe dit l'astuce qu'elle va utiliser un matin pressé. Total : 60 minutes. Adaptations : partir des contraintes réelles des élèves (temps, réveil tardif) sans les juger ; utiliser leur téléphone pour photographier leur création et la partager.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.12 à 5.3.15 – Supports, outils et ateliers accessibles

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qu'un entretien cognitif ? Combien de personnes faut-il environ ?
2. Pourquoi l'indice de lisibilité ne suffit-il pas pour valider un support ?
3. Citez quatre des huit questions pour analyser un outil pédagogique.
4. Décrivez en trois étapes l'animation d'un photolangage.
5. Citez deux adaptations d'un atelier pour des personnes âgées.
6. Dans le fil rouge des Tilleuls, citez deux adaptations de la communication.

Corrigé – Point d'étape 5.3.12 à 5.3.15

1. Une méthode de test où des personnes du public lisent ou utilisent le support à voix haute, puis répondent à des questions sur ce qu'elles ont compris ; 5 à 8 personnes.
2. Il ne mesure ni le sens des mots, ni les sigles, ni les images, ni la mise en page ; seul un test auprès du public montre la compréhension.

3. Qui l'a conçu ; contenu à jour ; objectifs ; public visé ; participation ; non-stigmatisation ; accessibilité ; adaptations nécessaires.
4. Choix silencieux d'une photo à partir d'une question ouverte ; tour de parole où chacun explique son choix ; synthèse par l'animateur, sans jugement.
5. Rythme lent, grande police et bonne lumière, prise en compte de l'audition, recettes simples, place du lien social.
6. Invitation sur papier, message vocal WhatsApp enregistré par la référente familles, bouche-à-oreille par les mamans relais, pas d'inscription seulement en ligne.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe aux approfondissements.
3 ou 4 sur 6	Je relis les méthodes des sections 5.3.12 à 5.3.14.
Moins de 3 sur 6	Je relis les sections 5.3.12 à 5.3.15 et je refais les exercices d'application.

5.3.15 Fil rouge : la littératie au centre social des Tilleuls

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès a observé et adapté

- **Diagnostic** : lors de la passation du questionnaire à la sortie de l'école, 11 parents sur 48 ont demandé à Inès de lire les questions à voix haute ; 6 parents parlaient peu le français. Inès a donc réalisé la passation **en entretien oral**, avec l'aide d'une médiatrice parlant arabe et soninké.
- **Calcul** : 11 / 48 × 100 = **22,9 %** des parents ont eu besoin d'une lecture orale ; 6 / 48 × 100 = **12,5 %** parlaient peu le français. Ces chiffres ne sont pas des taux d'illettrisme : ils indiquent un **besoin d'adaptation**.
- **Supports** : les fiches recettes ont été refaites en **photos** (une photo par étape), avec des quantités en verres et en cuillères ; l'indice de lisibilité de la fiche « lentilles corail » est passé de 54 à 82 après réécriture ; la fiche a été testée par 3 mamans du groupe.
- **Animation** : à chaque atelier, Inès termine par un « tour de faire dire » : chaque binôme explique au groupe une astuce retenue.
- **Communication** : invitation sur papier, message vocal WhatsApp enregistré par la référente familles, bouche-à-oreille par les mamans relais ; pas d'inscription uniquement en ligne.
- **Évaluation** : questionnaire de satisfaction à **smileys** et question orale « Qu'allez-vous refaire à la maison ? ».

Fil rouge – centre social des tilleuls – Compléments : l'atelier « lire une étiquette » et le livret des Tilleuls

- **Atelier étiquettes** (intégré à l'atelier 4) : comparaison de deux céréales et de deux boissons, morceaux de sucre posés à côté des bouteilles ; à la question « Combien de morceaux de sucre dans cette bouteille de 33 cL ? », 2 parents sur 11 répondaient juste avant la démonstration (18,2 %), 9 sur 11 après (81,8 %).
- **Numératie** : Inès a remplacé « 400 g de fruits et légumes » par « 5 portions = 5 poings » et « 2 fois par semaine des légumes secs » par un calendrier illustré de la semaine.
- **Livret de recettes** : indice de lisibilité moyen des 12 fiches 84 (minimum 78, maximum 91) ; chaque recette en 6 photos au plus, quantités en verres et cuillères ; testé par 3 mamans (correction de 4 mots jugés difficiles : « émincer », « blanchir », « réserver », « assaisonner »).
- **Allophones** : 6 familles sur 12 parlent une autre langue à la maison ; une médiatrice a traduit oralement les consignes de sécurité ; les allergènes étaient signalés par pictogrammes.
- **Numérique** : 9 familles sur 12 utilisent WhatsApp : rappels vocaux la veille ; aucune inscription n'était

uniquement en ligne.

5.3.16 Six cas guidés pour s'entraîner à intégrer la littératie

Module · Référentiel et guide : voir 5.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Ces six cas reprennent les notions du chapitre dans l'ordre attendu par le jury : décrire la situation avec des chiffres, l'analyser avec les notions du cours, puis proposer des adaptations argumentées qui valent pour tout le public. Essayez de répondre avant de lire chaque corrigé.

Cas guidé 1 – L'affiche du menu végétarien au restaurant universitaire (données fictives)

Un restaurant universitaire propose chaque jour un plat végétarien, peu choisi. L'affiche actuelle, en police de 11 points, gris clair sur fond blanc, dit : « Dans le cadre de notre engagement en faveur d'une alimentation durable, nous vous proposons quotidiennement une alternative végétarienne équilibrée… » Elle compte 96 mots, 4 phrases et 175 syllabes. Une enquête auprès de 120 étudiants montre que 41 savent qu'un plat végétarien est proposé chaque jour ; 180 plats végétariens sont vendus sur 1 450 repas par jour.

Une nouvelle affiche est conçue avec des étudiants : 60 mots, 9 phrases, 87 syllabes, photo du plat du jour, texte noir. Deux semaines plus tard, 78 étudiants sur 130 interrogés connaissent l'offre et 255 plats végétariens sont vendus sur 1 480 repas.

Questions – Cas guidé 1

1. Calculez l'indice de lisibilité des deux affiches et les pourcentages avant et après (connaissance de l'offre, part des plats végétariens vendus).
2. Relevez trois défauts de l'ancienne affiche.
3. Peut-on attribuer toute la hausse des ventes à la nouvelle affiche ? Justifiez.
4. Proposez deux autres actions, en dehors de l'affiche, pour faire connaître le plat végétarien.

Corrigé – Cas guidé 1

1. Ancienne affiche : 96 / 4 = 24 mots par phrase ; 175 / 96 = 1,823 syllabe par mot ; L = 207 − 24,36 − 134,17 = **48,47** : difficile. Nouvelle : 60 / 9 = 6,67 ; 87 / 60 = 1,45 ; L = 207 − 6,77 − 106,72 = **93,51** : très facile. Connaissance de l'offre : 41 / 120 = **34,2 %** puis 78 / 130 = **60,0 %**. Part des plats végétariens : 180 / 1 450 = **12,4 %** puis 255 / 1 480 = **17,2 %**.

2. Contraste faible (gris clair sur blanc) ; petite police ; phrases longues et jargon (« dans le cadre de notre engagement », « alternative ») ; aucune image du plat ; le message principal (« un plat végétarien chaque jour ») n'apparaît pas d'abord.

3. Non : il n'y a pas de groupe de comparaison, et d'autres facteurs ont pu jouer en deux semaines (plats du jour plus appréciés, météo, bouche-à-oreille, prix). On parle d'une évolution favorable observée, à confirmer sur une plus longue période.

4. Une dégustation gratuite du plat végétarien à l'entrée du self ; une présentation du plat en première position sur la ligne de self ; une publication sur les réseaux sociaux des associations étudiantes avec la photo du jour ; un pictogramme « végétarien » sur le menu en ligne.

Cas guidé 2 – Le courrier aux parents après le bilan de santé de l'école (données fictives)

Lors du bilan de santé des élèves de 6 ans d'une circonscription, l'infirmière scolaire a mesuré 112 enfants ; 14 ont un indice de masse corporelle au-dessus de la zone habituelle pour leur âge. Les parents de ces 14 enfants ont reçu dans le cartable une lettre : « Votre enfant présente un IMC supérieur au 97e percentile des courbes de référence ; une prise en charge est recommandée. » Seuls 6 parents sont venus à la réunion

proposée. Une mère a dit : « J'ai cru que mon fils était malade. Il a lu la lettre avant moi. »

Questions – Cas guidé 2

1. Calculez la part d'enfants concernés et la part de parents venus à la réunion.

2. Expliquez le « 97e percentile » en fréquences naturelles, avec des mots simples.

3. Relevez les problèmes de littératie et d'éthique de ce courrier.

4. Proposez une autre façon d'informer ces familles.

Corrigé – Cas guidé 2

1. Enfants concernés : 14 / 112 = **12,5 %**. Parents venus : 6 / 14 = **42,9 %**.

2. « Si l'on range 100 enfants du même âge et du même sexe du plus mince au plus fort, votre enfant fait partie des 3 enfants les plus forts. » On ajoute que ce n'est pas une maladie, mais un repère qui invite à faire le point.

3. Littératie : vocabulaire technique (IMC, percentile, courbes de référence, prise en charge) ; aucune explication ni conseil concret ; aucune personne à contacter. Éthique : courrier transmis par le cartable, que l'enfant peut lire ; risque de stigmatisation et d'inquiétude ; le mot « prise en charge » fait penser à une maladie ; la confidentialité n'est pas garantie.

4. Un entretien individuel proposé par téléphone ou à la sortie de l'école, avec l'infirmière, sans l'enfant ; une courbe de corpulence montrée et expliquée oralement ; des conseils centrés sur toute la famille (repas, activité, sommeil), sans parler de régime ; l'orientation vers le médecin traitant ; un courrier envoyé par voie postale, court et en écriture claire, qui propose simplement un rendez-vous. Pour toutes les familles de l'école, une action collective non ciblée (atelier goûters, activité physique) évite de désigner les enfants.

Cas guidé 3 – L'application des menus de la cantine (données fictives)

Une commune de 2 400 élèves remplace l'affichage papier des menus par une application. Une enquête auprès de 300 parents montre : 171 ont installé l'application ; 120 consultent les menus chaque semaine ; 135 souhaitent garder un menu papier ; parmi les 63 parents d'enfants allergiques, 48 trouvent l'information sur les allergènes. Dans l'application, le texte est gris moyen (#8A8A8A, luminance relative 0,2542) sur fond blanc.

Questions – Cas guidé 3

1. Calculez les pourcentages de l'enquête.

2. Calculez le ratio de contraste du texte et concluez.

3. Analysez les risques de cette dématérialisation pour les familles.

4. Proposez quatre améliorations.

Corrigé – Cas guidé 3

1. Application installée : 171 / 300 = **57,0 %** ; consultation hebdomadaire : 120 / 300 = **40,0 %** ; menu papier souhaité : 135 / 300 = **45,0 %** ; parents d'enfants allergiques qui trouvent l'information : 48 / 63 = **76,2 %**, donc **23,8 %** ne la trouvent pas.

2. (1 + 0,05) / (0,2542 + 0,05) = 1,05 / 0,3042 = **3,45** : sous le seuil de 4,5 pour un texte courant ; seul un grand texte serait conforme.

3. 43 % des parents n'ont pas l'application et 60 % ne consultent pas les menus chaque semaine : les familles éloignées du numérique perdent l'information. Pour les allergies, près d'un parent concerné sur quatre ne

trouve pas l'information : c'est un risque pour la sécurité des enfants. Le faible contraste gêne la lecture.

4. Garder un affichage papier à l'entrée de l'école et sur le site de la mairie ; ajouter dans l'application des pictogrammes d'allergènes et un texte foncé (par exemple #595959, ratio de 7,0) ; envoyer chaque mois le menu papier aux familles qui le demandent ; organiser une présentation de l'application lors d'une réunion de parents, avec un « faire faire » (trouver les allergènes du jeudi) ; prévoir un contact téléphonique pour les parents d'enfants allergiques.

Cas guidé 4 – Les boissons énergisantes au club de football (données fictives, étiquette courante)

Un club de football amateur accueille 46 joueurs de 13 à 17 ans. L'entraîneur vous alerte : 21 jeunes boivent une boisson énergisante au moins une fois par semaine, dont 14 avant les matchs. L'étiquette d'une canette de 250 mL courante indique pour 100 mL : 11 g de sucres et 32 mg de caféine. Un jeune dit : « Ça donne des ailes, c'est fait pour le sport. »

Questions – Cas guidé 4

1. Calculez la part de jeunes concernés, puis le sucre (en grammes et en morceaux) et la caféine d'une canette.
2. Un jeune de 50 kg boit deux canettes avant un match. Comparez sa dose de caféine à la valeur de 3 mg par kilogramme de poids corporel retenue par l'EFSA (2015) pour les enfants et adolescents.
3. Analysez la phrase du jeune avec la notion de littératie critique.
4. Proposez une séance de 45 minutes avec les jeunes, puis une action avec le club.

Corrigé – Cas guidé 4

1. Au moins une fois par semaine : 21 / 46 = **45,7 %** ; avant les matchs : 14 / 46 = **30,4 %**. Sucres : 11 × 2,5 = **27,5 g**, soit **5,5 morceaux** (55 % du repère de 50 g de sucres libres pour un adulte) ; caféine : 32 × 2,5 = **80 mg**.

2. Valeur de l'EFSA : 3 × 50 = **150 mg**. Deux canettes : 2 × 80 = **160 mg**, au-dessus de cette valeur. L'ANSES (2013) déconseille la consommation de boissons énergisantes par les enfants et les adolescents, et au cours d'un effort physique.

3. Le jeune reprend un slogan publicitaire comme une information de santé. La littératie critique consiste à se demander qui parle (une marque), dans quel but (vendre) et ce que disent les sources indépendantes (pas d'intérêt pour la performance, risques liés à la caféine et au sucre).

4. Séance : 10 minutes de « vrai ou faux » sur les boissons ; 10 minutes pour poser les morceaux de sucre à côté de la canette ; 15 minutes d'analyse d'une publicité en petits groupes (qui, pourquoi, quelles preuves) ; 10 minutes pour fabriquer une boisson de match (eau, un peu de jus) et faire dire « ce que je bois avant et pendant le match ». Action avec le club : remplacer la vente de boissons énergisantes à la buvette par de l'eau et des fruits ; informer les parents par un message court ; impliquer l'entraîneur, que les jeunes écoutent.

Cas guidé 5 – Cuisiner les légumes du chantier d'insertion (données fictives)

Un chantier d'insertion en maraîchage emploie 18 salariés. Lors d'entretiens oraux, 7 disent lire difficilement, 5 parlent peu le français et 12 disent ne pas cuisiner les légumes qu'ils récoltent (« je ne sais pas quoi faire des courgettes »). L'encadrante propose un atelier « tortilla de courgettes » pour 6 personnes : 6 œufs (3,30 € les 12), 600 g nets de pommes de terre (1,20 € le kg, 15 % de pertes), 600 g de courgettes du jardin (sans coût), 100 g nets d'oignon (1,80 € le kg, 10 % de pertes), 30 g d'huile d'olive (6,50 € le kg), sel et poivre (forfait de 0,20 €). Au premier atelier, 14 salariés sont présents ; 11 réussissent à montrer comment couper et cuire les légumes.

Questions – Cas guidé 5

1. Calculez les pourcentages du diagnostic, de la présence et de la réussite du « faire faire ».

2. Calculez le coût de la recette pour 6 et par portion.

3. Situez les difficultés dans les domaines de la littératie alimentaire.

4. Proposez trois adaptations de l'atelier et un support à emporter.

Corrigé – Cas guidé 5

1. Lisent difficilement : 7 / 18 = **38,9 %** ; parlent peu le français : 5 / 18 = **27,8 %** ; ne cuisinent pas les légumes récoltés : 12 / 18 = **66,7 %**. Présence : 14 / 18 = **77,8 %** ; réussite : 11 / 14 = **78,6 %**.

2. Œufs : 6 × 3,30 / 12 = 1,65 € ; pommes de terre : 600 / 0,85 = 705,9 g bruts, soit 0,85 € ; oignon : 100 / 0,90 = 111,1 g bruts, soit 0,20 € ; huile : 0,030 × 6,50 = 0,20 € ; forfait : 0,20 €. Total : 1,65 + 0,85 + 0,20 + 0,20 + 0,20 = **3,09 €** (calcul non arrondi : 3,09 €), soit environ **0,52 €** par portion.

3. Préparer : ne pas savoir cuisiner les légumes récoltés (domaine principal). Planifier et gérer : utiliser ce que l'on a, sans gaspiller. Sélectionner : l'accès aux légumes est déjà assuré par le chantier, c'est un atout. Manger : faire goûter et partager un repas entre collègues.

4. Démonstration de chaque geste avant de le faire faire ; recette en 6 photos, une action par photo, quantités en nombre (« 6 œufs », « 4 pommes de terre moyennes ») ; binômes mélangeant lecteurs et non-lecteurs, et participants de même langue si besoin ; dégustation au repas de midi du chantier. Support : une carte recette en photos, avec un pictogramme de saison pour chaque légume, et un message vocal de l'encadrante qui reprend les étapes.

Cas guidé 6 – Former les aides à domicile au « faire dire » (données fictives)

Un service d'aide à domicile veut prévenir la dénutrition des personnes âgées qu'il accompagne. Les 24 aides à domicile ont suivi une formation de 3 heures : conseils d'enrichissement des repas, écriture claire, « faire dire ». Avant et après la formation, une responsable a observé 2 visites par aide (48 visites) et noté si l'aide vérifiait la compréhension d'un conseil. Elle a aussi demandé à 24 personnes accompagnées d'expliquer un conseil d'enrichissement reçu. Résultats : vérification de la compréhension dans 5 visites sur 48 avant, 29 sur 48 après ; explication correcte par 9 personnes sur 24 avant, 17 sur 24 après.

Questions – Cas guidé 6

1. Calculez les pourcentages avant et après, et leur évolution en points.

2. Montrez que cette action relève à la fois de la littératie des personnes et de la littératie organisationnelle.

3. Citez deux limites de cette évaluation.

4. Proposez deux actions pour faire durer les effets de la formation.

Corrigé – Cas guidé 6

1. Vérification de la compréhension : 5 / 48 = **10,4 %** avant, 29 / 48 = **60,4 %** après, soit **+ 50,0 points**. Explication correcte par les personnes accompagnées : 9 / 24 = **37,5 %** avant, 17 / 24 = **70,8 %** après, soit **+ 33,3 points**.

2. Littératie des personnes : les personnes âgées comprennent mieux et savent mieux expliquer les conseils d'enrichissement. Littératie organisationnelle : le service forme son personnel et change ses pratiques de communication, ce qui rend l'information plus accessible pour toutes les personnes accompagnées.

3. Observation par une responsable, qui peut modifier le comportement des aides pendant la visite (elles savent qu'on les observe) ; mesure juste après la formation, sans recul sur la durée ; pas de groupe témoin ; petit effectif.

4. Un temps d'échange de 15 minutes lors des réunions d'équipe mensuelles pour partager des situations ; une fiche aide-mémoire « 3 conseils, 1 question de faire dire » dans le classeur de chaque domicile ; une nouvelle observation six mois plus tard ; la formation des nouvelles aides à leur arrivée.

5.4 Approfondissements

5.4.1 La littératie numérique en santé (e-santé)

La **littératie numérique en santé** (*eHealth literacy*, Norman et Skinner, 2006) est la capacité à rechercher, trouver, comprendre et évaluer l'information de santé en ligne et à l'utiliser. Elle combine six littératies : traditionnelle, en santé, informationnelle, scientifique, médiatique et informatique. Avec la dématérialisation des démarches (Mon espace santé, prise de rendez-vous, inscriptions aux ateliers), les personnes en situation d'**illectronisme** risquent d'être exclues : les **Conseillers numériques** et les **espaces France Services** peuvent être des partenaires d'une action de santé publique.

Méthode pas à pas – Juger la fiabilité d'une information de santé en ligne : 6 questions

1. Qui est l'auteur ? Est-il identifié, compétent (professionnel de santé, institution) ?

2. Quel est l'objectif : informer ou vendre ?

3. D'où viennent les informations : sources citées, études, recommandations officielles ?

4. Quand le contenu a-t-il été publié ou mis à jour ?

5. Le contenu est-il **cohérent** avec les repères officiels (Santé publique France, ANSES, HAS) ?

6. Promet-il des **résultats miraculeux**, rapides, sans effort ? (signal d'alerte).

Mesurer la littératie numérique en santé : l'échelle eHEALS

Norman et Skinner (2006) ont proposé une échelle courte, l'**eHEALS** (*eHealth Literacy Scale*), traduite et validée en français. Elle comporte **8 affirmations** sur la capacité à trouver, utiliser et juger l'information de santé sur internet. La personne répond pour chacune sur une échelle de 1 (« pas du tout d'accord ») à 5 (« tout à fait d'accord »). Le **score total** va donc de **8 à 40** : plus il est élevé, plus la personne se sent capable d'utiliser l'information de santé en ligne.

N°	Idée de l'affirmation (formulation simplifiée)	Compétence
1	Je sais quelles ressources de santé existent sur internet.	Accéder
2	Je sais où trouver sur internet des ressources utiles.	Accéder
3	Je sais comment trouver ces ressources.	Accéder
4	Je sais utiliser internet pour répondre à mes questions de santé.	Comprendre
5	Je sais utiliser l'information trouvée pour m'aider.	Appliquer
6	J'ai les compétences pour évaluer les ressources trouvées.	Évaluer
7	Je sais distinguer les ressources de bonne et de mauvaise qualité.	Évaluer
8	Je me sens en confiance pour utiliser l'information d'internet pour décider.	Appliquer

Attention – Une mesure déclarative, pas un test

L'eHEALS mesure ce que la personne **pense** savoir faire, pas ce qu'elle sait réellement faire. Une personne très confiante peut se tromper sur la fiabilité d'un site. Il n'existe pas de seuil officiel en France : dans un projet, on utilise surtout l'échelle pour **comparer** un groupe avant et après une action, en toute

confidentialité et avec l'accord des participants.

Exemple – Le score de M. B. et l'évaluation d'un atelier

M. B., 62 ans, répond 4, 4, 3, 2, 2, 3, 2, 2. Son score est 4 + 4 + 3 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2 = **22 sur 40**, soit une moyenne de 22 / 8 = **2,75** par affirmation. Ses réponses sont les plus basses pour l'utilisation et l'évaluation (affirmations 4 à 8) : il sait que des ressources existent, mais il ne sait pas juger leur qualité.

Huit participants d'un atelier « Bien s'informer sur l'alimentation » à l'espace France Services remplissent l'échelle avant et un mois après l'atelier (données fictives).

Participant	1	2	3	4	5	6	7	8
Avant	18	22	25	30	16	27	21	24
Après	24	26	29	32	22	30	25	28
Progression	+ 6	+ 4	+ 4	+ 2	+ 6	+ 3	+ 4	+ 4

Moyenne avant : 183 / 8 = **22,875**, soit environ 22,9. Moyenne après : 216 / 8 = **27**. Progression moyenne : **+ 4,1 points**. Six participants sur huit gagnent au moins 4 points. Ce résultat est encourageant, mais l'effectif est très petit et il n'y a pas de groupe de comparaison : on parle d'une **évolution observée**, pas d'une preuve d'efficacité.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.38

Trois personnes ont rempli l'eHEALS au début d'un atelier.

- Awa : 5, 4, 4, 4, 3, 3, 4, 4.
- Gérard : 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1.
- Inès : 4, 5, 5, 4, 4, 2, 2, 3.

1. Calculez le score de chacune.

2. Pour Inès, repérez les affirmations les plus basses et la compétence correspondante.

3. Proposez une adaptation de l'atelier pour Gérard, sans le mettre à l'écart du groupe.

Corrigé – Exercice d'application 5.39

1. Awa : 31 sur 40 ; Gérard : 12 sur 40 ; Inès : 29 sur 40.

2. Inès répond 2, 2 et 3 aux affirmations 6, 7 et 8 : elle trouve facilement l'information, mais se sent peu capable de l'**évaluer** et de l'utiliser pour décider. L'atelier doit insister sur les six questions de fiabilité.

3. Gérard se sent peu à l'aise dès l'accès à internet. On peut former des binômes (Gérard avec Awa par exemple), partir de son propre téléphone, montrer un seul site fiable (manger-bouger.fr) enregistré en favori et lui proposer un rendez-vous avec le conseiller numérique, sans souligner son score devant les autres.

5.4.2 La médiation en santé et l'interprétariat

La **médiation en santé** est reconnue par la loi de modernisation de notre système de santé (2016, article L. 1110-13 du Code de la santé publique) et encadrée par un référentiel de la HAS (2017) : un médiateur fait le **lien** entre des publics éloignés et les professionnels, facilite l'accès aux droits et aux soins et aide les professionnels à adapter leurs pratiques. L'**interprétariat linguistique** professionnel dans le domaine de la santé fait l'objet d'un autre référentiel de la HAS (2017). Dans un projet en quartier prioritaire, s'appuyer sur un médiateur ou des **habitants relais** est souvent plus efficace que la traduction d'une affiche.

Médiateur, interprète, habitant relais : qui fait quoi ?

Ces trois intervenants sont souvent confondus (la conduite d'un entretien avec un interprète est détaillée en 5.3.11). Ils sont pourtant complémentaires, et le diététicien doit savoir lequel solliciter selon le besoin.

	Médiateur en santé	Interprète professionnel	Habitant relais (ou pair)
Rôle principal	Faire le lien entre le public et les services ; faciliter l'accès aux droits et aux soins	Traduire fidèlement les propos, dans les deux sens	Informer, mobiliser et accompagner ses voisins ou sa communauté
Formation	Formation spécifique (référentiel HAS 2017)	Formation à l'interprétariat et à la déontologie (neutralité, secret)	Formation courte, souvent par la structure
Statut	Salarié d'une association, d'une collectivité, d'un hôpital	Professionnel, sur place, par téléphone ou par vidéo	Bénévole ou indemnisé
Exemple dans un projet alimentaire	Accompagner des familles vers le centre social et l'épicerie solidaire	Permettre un entretien individuel avec une mère qui parle tamoul	Inviter les voisines à l'atelier et traduire les idées clés de façon informelle
Limite	Ne remplace pas les professionnels de santé	Ne donne pas son avis, ne conseille pas	Ne doit pas traduire des informations médicales individuelles ou confidentielles

En France, le **Programme national de médiation sanitaire**, lancé en 2011 pour les personnes vivant en habitat précaire (bidonvilles, squats), a montré que la présence régulière de médiateurs améliore l'ouverture des droits, la vaccination et le suivi des grossesses. La médiation en santé se développe aussi dans les quartiers prioritaires (adultes-relais, ateliers santé ville).

Méthode pas à pas – Travailler avec un médiateur dans un projet

1. L'associer dès le diagnostic : il connaît les habitudes, les freins et les lieux fréquentés par le public.

2. Définir ensemble les rôles : qui invite, qui anime, qui traduit, qui fait le lien avec les familles après l'atelier.

3. Partager les messages clés : le diététicien vérifie l'exactitude, le médiateur vérifie que les mots et les exemples conviennent au public.

4. Préparer la séance ensemble : supports, exemples d'aliments, moments de reformulation.

5. Faire le bilan à deux : ce qui a été compris, ce qui a surpris, ce qu'il faut changer.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.40

Pour chaque besoin, indiquez l'intervenant le plus adapté (médiateur, interprète professionnel, habitant relais) et justifiez.

a) Mme R., qui ne parle que le bengali, vient pour un entretien sur l'alimentation de son enfant diabétique.

b) Le centre social veut faire connaître un nouvel atelier cuisine aux familles d'un immeuble.

c) Des familles vivant dans un campement ne connaissent pas leurs droits à la complémentaire santé solidaire ni l'épicerie solidaire.

d) Un atelier collectif réunit des femmes qui parlent arabe et qui comprennent un peu le français ; une participante bilingue propose son aide.

Corrigé – Exercice d'application 5.41

a) **Interprète professionnel** : il s'agit d'informations de santé individuelles et confidentielles, qui demandent une traduction fidèle et neutre ; on évite de faire traduire par un enfant ou un proche.

b) **Habitant relais** : il connaît les familles, inspire confiance et mobilise par le bouche-à-oreille.

c) **Médiateur en santé** : il fait le lien avec les services, accompagne l'ouverture des droits et oriente vers

l'épicerie solidaire.

d) **Habitant relais** (la participante bilingue) pour les consignes et les idées générales d'un atelier collectif, à condition de lui demander son accord, de ne pas lui confier de questions personnelles et de vérifier la compréhension de toutes avec des images et le « faire dire ».

5.4.3 Les organisations « amies de la littératie »

Agir sur la littératie, ce n'est pas seulement former les personnes : c'est aussi **simplifier l'environnement**. Une structure « littératie-amicale » (*health literate organization*, Brach et coll., 2012) : forme son personnel, associe les usagers à la conception des documents, rend les lieux faciles à trouver (signalétique, pictogrammes), simplifie les formulaires et propose de l'aide, communique clairement les coûts, vérifie la compréhension. Le diététicien peut proposer à un centre social, à une cuisine centrale ou à une épicerie solidaire un **audit** simple de ses supports (fiche-outil O5.3).

Les dix caractéristiques d'une organisation « amie de la littératie »

Brach et ses collègues (2012, *Institute of Medicine*, États-Unis) décrivent **dix caractéristiques** d'une organisation de santé qui facilite la vie des personnes ayant une littératie limitée. Elles s'adaptent facilement à un centre social, une épicerie solidaire, un service de restauration ou une association.

N°	Caractéristique (formulation adaptée)	Exemple dans une épicerie solidaire
1	La direction fait de la littératie une priorité.	Le projet associatif mentionne l'accessibilité des informations.
2	La littératie est intégrée à la planification et à l'évaluation.	Un indicateur « compréhension » figure dans le bilan annuel.
3	Le personnel est formé.	Les bénévoles ont suivi une formation « communiquer pour tous ».
4	Le public participe à la conception des supports.	Les affiches sont testées auprès de bénéficiaires.
5	L'organisation répond à des niveaux de compétences variés, sans stigmatiser.	Les informations existent à l'écrit, en images et à l'oral.
6	La communication orale est claire et la compréhension est vérifiée.	Les bénévoles pratiquent le « faire dire » à l'accueil.
7	L'accès à l'information et l'orientation sont faciles.	Signalétique avec pictogrammes, plan affiché, horaires clairs.
8	Les documents écrits, audiovisuels et numériques sont faciles à comprendre et à utiliser.	Fiches recettes en écriture claire, avec photos.
9	La littératie est prise en compte dans les situations à risque.	Information claire sur les allergènes et les dates de consommation.
10	Les coûts et les droits sont expliqués clairement.	Le prix restant à payer par la famille est affiché simplement.

Méthode pas à pas – Réaliser un audit rapide avec une grille à 3 niveaux

1. Noter chaque caractéristique : 0 = absent ; 1 = partiel ; 2 = en place. Le total est sur 20.

2. Croiser les regards : remplir la grille avec l'équipe et avec deux ou trois usagers, puis comparer.

3. Exprimer le résultat en pourcentage du maximum, pour suivre l'évolution d'une année sur l'autre.

4. Choisir deux ou trois priorités : les caractéristiques notées 0, en commençant par celles qui sont faciles à améliorer et utiles au public.

5. Fixer une date pour refaire l'audit (par exemple dans un an).

Exemple – L'audit de l'épicerie solidaire « Le Panier partagé » (données fictives)

Notes obtenues pour les caractéristiques 1 à 10 : 2, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 2. Total : **11 sur 20**, soit 11 / 20 × 100 = **55 %**.

Les deux caractéristiques notées 0 sont la formation des bénévoles (3) et la qualité des documents (8). L'équipe retient deux priorités : une formation de deux heures pour les bénévoles et la réécriture des cinq fiches recettes en écriture claire, testées auprès de six bénéficiaires.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.42

La cuisine centrale d'une ville obtient les notes suivantes pour les caractéristiques 1 à 10 : 1, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 0 (données fictives).

1. Calculez le total et le pourcentage.
2. Identifiez les caractéristiques absentes.
3. Choisissez deux priorités et proposez pour chacune une action concrète liée aux menus ou à l'information des familles.

Corrigé – Exercice d'application 5.43

1. Total : 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 0 = **8 sur 20**, soit **40 %**.
2. Caractéristiques notées 0 : la littératie dans la planification et l'évaluation (2), la formation du personnel (3), la participation du public (4), la clarté des coûts (10).
3. Exemples : **participation du public (4)** : tester le nouvel affichage des menus et des allergènes auprès de 10 parents et d'une classe d'élèves avant de le diffuser ; **coûts (10)** : présenter le tarif de la cantine selon le quotient familial dans un tableau simple, avec un exemple chiffré et le contact d'une personne qui aide à faire la démarche. D'autres choix sont possibles s'ils sont justifiés.

5.4.4 La littératie en santé des professionnels et des organisations

La littératie n'est pas seulement l'affaire du public : les **professionnels** doivent être formés à communiquer clairement, et les **organisations** à réduire la complexité de leurs démarches (5.4.3). En France, la stratégie nationale de santé et plusieurs plans régionaux intègrent désormais la littératie en santé ; des formations courtes (« communiquer pour tous », faire dire, FALC) sont proposées par les instances régionales d'éducation et de promotion de la santé. Pour un diététicien, c'est une compétence transversale, utile en consultation (BC1), en restauration (BC2 : menus, affichage des allergènes) et en santé publique.

Former une équipe à communiquer clairement : un exemple

Former les professionnels est l'une des actions les plus rentables : une seule formation améliore ensuite des centaines d'échanges avec le public. Le diététicien peut concevoir et animer une courte formation pour une équipe d'animateurs, d'agents de restauration ou de bénévoles.

Exemple – Deux demi-journées pour l'équipe d'un centre social (données fictives)

Public : 14 animateurs et bénévoles du centre social. **Durée** : deux séances de 3 heures.

Objectifs : à la fin de la formation, les participants seront capables de réécrire une consigne en écriture claire, de pratiquer le « faire dire » et de repérer trois signaux possibles de difficulté de lecture, sans stigmatiser.

Séance	Contenu	Méthode
1	Qu'est-ce que la littératie ? Les chiffres de HLS19 ; les précautions universelles	Photolangage, quiz à main levée

Séance	Contenu	Méthode
1	Les règles d'écriture claire	Réécriture en binômes de trois documents du centre
2	Le « faire dire » et l'accueil	Jeux de rôle filmés avec l'accord des participants
2	Plan d'action de l'équipe	Chaque binôme choisit un support à améliorer dans le mois

Évaluation : un quiz de 10 questions est proposé avant et après la formation.

Agent	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Avant	4	6	5	3	7	5	6	4	5	6	3	5	7	6
Après	8	8	7	7	9	8	8	7	8	9	6	8	9	8

Moyenne avant : 72 / 14 = **5,1 sur 10** ; moyenne après : 110 / 14 = **7,9 sur 10** ; progression moyenne : **+ 2,7 points**. Après la formation, 10 agents sur 14, soit **71,4 %**, obtiennent au moins 8 sur 10.

Coût : intervention du diététicien 2 × 3 h × 45 € = 270 € ; pause et documents 14 × 2 × 3,50 € = 98 € ; total **368 €**, soit **26,29 €** par participant.

Attention – Évaluer la pratique, pas seulement les connaissances

Un bon score au quiz ne prouve pas que les pratiques changent. Pour aller plus loin, on observe quelques accueils (avec l'accord des agents), on compte les supports réécrits trois mois plus tard ou on interroge les usagers sur la clarté des informations reçues. On retrouve les niveaux d'évaluation des connaissances, des pratiques et des résultats pour le public (chapitre 9).

À vous de jouer – Exercice d'application 5.44

Le service de restauration d'un EHPAD vous demande une formation d'une séance de 2 heures pour 9 agents qui servent les repas et présentent les menus aux résidents.

1. Formulez deux objectifs pédagogiques.
2. Proposez le déroulé de la séance en trois temps, avec une méthode active pour chacun.
3. Calculez le coût si votre intervention est facturée 45 € de l'heure et si les documents coûtent 2 € par agent.
4. Proposez un indicateur de pratique à mesurer un mois plus tard.

Corrigé – Exercice d'application 5.45

1. Exemples : « présenter oralement le menu du jour en phrases courtes, en montrant le plat » ; « vérifier par le "faire dire" qu'un résident a compris le choix proposé ».
2. Exemple : 20 minutes de mise en situation (un agent présente un menu écrit en jargon, les autres jouent les résidents) puis échange ; 50 minutes d'atelier de réécriture des menus en mots simples avec photos ; 50 minutes de jeux de rôle sur la présentation du menu et le « faire dire », en tenant compte des troubles de l'audition et de la vue.
3. 2 × 45 = 90 € ; 9 × 2 = 18 € ; total **108 €**, soit **12 €** par agent.
4. Exemple : part des repas observés où le menu est présenté oralement avec le plat montré (observation de 20 services) ; ou nombre de menus réécrits et affichés en gros caractères.

5.4.5 L'intelligence artificielle et la simplification des textes

Les outils d'intelligence artificielle générative peuvent aider à **simplifier** un texte, proposer des versions dans d'autres langues ou générer des idées d'images ; ils peuvent aussi introduire des **erreurs** (« hallucinations »), des simplifications abusives ou des traductions inexactes. Leur usage professionnel suppose : de ne pas y saisir de données personnelles ou de santé (RGPD, chapitre 6) ; de **vérifier** chaque information auprès des sources officielles ; de faire **relire** par une personne compétente (et par le public pour le FALC) ; d'assumer la responsabilité du contenu diffusé. La compétence C3.3 du référentiel mentionne explicitement la connaissance des enjeux de l'IA.

Utiliser une IA pour simplifier un texte : une méthode prudente

Les règles juridiques et la sécurité des données sont traitées au chapitre 20. Ici, on s'intéresse à la question de la littératie : comment une intelligence artificielle peut **aider** à rendre un texte plus clair sans **dégrader** l'information.

Méthode pas à pas – Simplifier un texte avec une IA en cinq étapes

1. Préparer un texte source exact, déjà validé, sans aucune donnée personnelle (pas de nom, pas de situation de santé individuelle).

2. Donner une consigne précise : le public visé, le niveau de langue, la longueur, les règles d'écriture claire, les mots à conserver (« légumes secs », « Nutri-Score »).

3. Comparer phrase par phrase le texte produit avec le texte source : chaque chiffre, chaque repère et chaque conseil doit être identique ou équivalent.

4. Vérifier les repères auprès des sources officielles datées (Santé publique France, ANSES, HAS) et noter la date de vérification.

5. Tester le texte final auprès de quelques personnes du public (entretien cognitif, 5.3.12) ; pour un texte FALC, la relecture par des personnes en situation de handicap intellectuel reste obligatoire.

Attention – Les erreurs typiques d'une simplification automatique

- **Chiffre modifié** : une quantité, une fréquence ou une unité change (« par semaine » devient « par jour »).
- **Nuance supprimée** : « limiter » devient « supprimer », « au moins » disparaît.
- **Conseil inventé** : une recommandation qui n'existait pas dans le texte source apparaît.
- **Source inventée** : une étude ou un organisme cité n'existe pas.
- **Ton infantilisant** : simplifier ne veut pas dire parler à un adulte comme à un enfant.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.46

Une collègue a demandé à une IA de simplifier un texte sur les repères alimentaires de Santé publique France (2019). Voici le résultat. Repérez les erreurs et corrigez-les.

« Mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Les jus de fruits comptent : vous pouvez boire 5 verres de jus pour remplacer les fruits. Mangez des légumes secs (lentilles, pois chiches) une fois par mois. Ne mangez plus jamais de charcuterie. Une étude de l'université de Lyon de 2023 montre que le pain complet fait maigrir. »

Corrigé – Exercice d'application 5.47

- « Au moins 5 fruits et légumes par jour » : **correct**.
- Les jus : **erreur**. Le repère conseille de ne pas boire plus d'un petit verre de jus de fruits par jour ; les jus ne remplacent pas les fruits entiers.
- Légumes secs : **erreur de fréquence**. Le repère est **au moins deux fois par semaine**.
- Charcuterie : **nuance supprimée**. Le repère est de **limiter** la charcuterie à **150 g par semaine**, pas de

l'interdire.

- L'étude citée : **source invérifiable**, probablement inventée ; le texte source ne la contenait pas. On la supprime.

Conclusion : le texte simplifié contient quatre erreurs sur cinq phrases. Il ne doit pas être diffusé sans une vérification complète, phrase par phrase.

5.4.6 Développer la littératie alimentaire des enfants à l'école

L'école est un lieu privilégié pour développer la littératie alimentaire dès l'enfance, car elle touche tous les enfants, quel que soit leur milieu social. Le **parcours éducatif de santé** (circulaire du 28 janvier 2016) organise, de la maternelle au lycée, trois axes : l'éducation à la santé, la prévention et la protection de la santé. L'éducation à l'alimentation et au goût y a toute sa place. L'éducation sensorielle (classes du goût) est présentée aux chapitres 1 et 11 ; on s'intéresse ici aux compétences de **lecture**, de **calcul** et d'**esprit critique** liées à l'alimentation.

Âge	Compétences de littératie alimentaire à développer	Exemple d'activité
Maternelle	Nommer les aliments, les classer, reconnaître des familles	Jeu de tri avec de vrais aliments et des photos
Élémentaire (CP-CM2)	Lire une liste d'ingrédients simple, repérer le sucre, comparer deux produits	Poser les morceaux de sucre à côté de l'emballage
Collège	Lire le tableau nutritionnel, calculer pour une portion, analyser une publicité	Comparer deux céréales, décoder une publicité en ligne
Lycée	Juger une information en ligne, débattre d'un sujet (influenceurs, régimes)	Enquête sur la fiabilité de trois vidéos

Exemple – Une séance « Le sucre caché » en CM1 (données fictives)

Une classe de CM1 compte 26 élèves. Avant la séance, 9 élèves savent montrer où se trouve le sucre sur un emballage, soit 9 / 26 = **34,6 %**. La diététicienne apporte un yaourt aromatisé de 125 g qui contient 13 g de sucres pour 100 g : 13 × 1,25 = **16,25 g** de sucres, soit environ **3 morceaux** de 5 g (3,25 exactement). Les élèves posent les morceaux à côté du pot, puis cherchent l'information sur trois autres emballages en binômes. Une semaine plus tard, l'enseignante refait le test : 21 élèves sur 26 réussissent, soit **80,8 %**.

La séance respecte les règles de la littératie : objets réels, consignes courtes, travail à deux, vérification par le « faire dire », aucun aliment présenté comme « interdit ». Un mot simple est remis aux parents avec l'activité à refaire à la maison.

Attention – Ne pas culpabiliser les enfants ni leurs familles

Un enfant n'est pas responsable des achats de sa famille. Les messages doivent rester positifs (« on peut choisir », « on peut goûter »), éviter les aliments « bons » ou « mauvais » et ne jamais commenter le contenu d'un goûter apporté de la maison devant la classe. Associer les parents (réunion, atelier parents-enfants) renforce l'action et évite le conflit de loyauté.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.48

Un collège vous demande une séance de 55 minutes pour une classe de 5e sur les boissons.

1. Formulez un objectif de littératie fonctionnelle et un objectif de littératie critique.
2. Une boisson aux fruits de 33 cL contient 9 g de sucres pour 100 mL. Calculez la quantité de sucres et le nombre de morceaux de 5 g.

3. Proposez le déroulé de la séance en trois temps.
4. Proposez une action pour associer les familles.

Corrigé – Exercice d'application 5.49

1. Fonctionnel : « trouver sur l'étiquette la quantité de sucres pour 100 mL et la calculer pour la bouteille ». Critique : « repérer dans une publicité les techniques utilisées pour donner envie d'acheter une boisson ».
2. 9 × 3,3 = **29,7 g** de sucres, soit environ **6 morceaux** de 5 g (5,94).
3. Exemple : 15 minutes de lecture d'étiquettes en binômes (quatre boissons, calcul pour la bouteille, morceaux de sucre posés à côté) ; 25 minutes d'analyse de deux publicités en petits groupes (qui parle, pour quoi faire, quelles images, quelles preuves) ; 15 minutes de mise en commun et de « faire dire » : chaque groupe énonce une chose qu'il retient.
4. Exemple : les élèves conçoivent eux-mêmes une affiche ou une courte vidéo pour les parents, présentée à la réunion parents-professeurs ; un message court et traduit si besoin est envoyé par l'application de l'établissement.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.4 – Approfondissements

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Combien d'affirmations compte l'échelle eHEALS, et entre quelles valeurs varie son score ?
2. Quelle est la différence principale entre un médiateur en santé et un interprète professionnel ?
3. Citez quatre des dix caractéristiques d'une organisation « amie de la littératie ».
4. Une grille d'audit donne 13 sur 20. Exprimez ce résultat en pourcentage.
5. Citez trois erreurs typiques d'un texte simplifié par une IA.
6. Pourquoi faut-il éviter de commenter le goûter d'un enfant devant la classe ?

Corrigé – Point d'étape 5.4

1. 8 affirmations notées de 1 à 5 ; score de 8 à 40.
2. Le médiateur fait le lien entre le public et les services et facilite l'accès aux droits ; l'interprète traduit fidèlement et de façon neutre, sans conseiller.
3. Direction engagée ; littératie dans la planification et l'évaluation ; personnel formé ; participation du public ; réponse à des niveaux variés sans stigmatiser ; communication orale claire et vérifiée ; orientation facile ; documents faciles à comprendre ; situations à risque ; coûts expliqués clairement.
4. 13 / 20 × 100 = 65 %.
5. Chiffre modifié ; nuance supprimée ; conseil inventé ; source inventée ; ton infantilisant.
6. L'enfant n'est pas responsable des achats de sa famille ; le commentaire le stigmatise et crée un conflit de loyauté entre l'école et la famille.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie « Pour aller plus loin ».
3 ou 4 sur 6	Je relis les méthodes et les exemples de la partie 5.4.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 5.4 et je refais les exercices d'application.

5.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Mesurer la littératie en santé

Plusieurs instruments existent : **HLS-EU-Q47** et ses versions courtes (Q16, Q12 du HLS19), fondés sur l'autoévaluation des difficultés ; tests de performance comme le **NVS** (*Newest Vital Sign*, Weiss et coll., 2005), qui demande de lire une étiquette de crème glacée et de répondre à 6 questions (calculs de portions, d'énergie, d'allergènes) ; le **HLQ** (*Health Literacy Questionnaire*, Osborne et coll., 2013), à 9 dimensions, conçu pour orienter les interventions (démarche **Ophelia**). Les mesures autodéclarées et les tests de performance ne mesurent pas la même chose ; en pratique de terrain, on ne « teste » pas le public, on applique les précautions universelles.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Littératie critique et capacité d'agir collective

Nutbeam (2008) oppose deux conceptions : la littératie comme **facteur de risque** (à repérer et à compenser dans les soins) et la littératie comme **atout** (*asset*) à développer par l'éducation, qui renforce le pouvoir d'agir des personnes et des communautés. Cette seconde conception rejoint la Charte d'Ottawa et la pédagogie de Paulo Freire (*Pédagogie des opprimés*, 1968) : apprendre à « lire le monde » pour le transformer. Dans un projet alimentaire, elle peut conduire un groupe d'habitants à interpeller la mairie sur l'offre de fruits et légumes de leur quartier.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Littératie et intelligence artificielle générative

Les outils d'intelligence artificielle générative (agents conversationnels) sont désormais utilisés par une partie du public pour s'informer sur l'alimentation et la santé. Ils peuvent simplifier un texte, mais produisent parfois des informations inexactes présentées avec assurance. La littératie **critique** inclut désormais la capacité à vérifier une réponse générée par une IA auprès de sources officielles ; le professionnel reste responsable des contenus qu'il diffuse.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La numératie et la perception des risques

Les recherches de Gerd Gigerenzer (Institut Max Planck, Berlin) montrent que de nombreuses personnes, y compris des professionnels de santé, interprètent mal les probabilités conditionnelles et les risques relatifs, alors qu'elles comprennent bien les **fréquences naturelles**. Exemple : « Sur 1 000 personnes, 10 ont la maladie ; le test est positif chez 9 d'entre elles et chez 99 des 990 non-malades » permet de calculer facilement que, parmi les 9 + 99 = 108 tests positifs, seuls 9 / 108 = **8,3 %** correspondent à une maladie réelle, alors que la même information exprimée en pourcentages (prévalence 1 %, sensibilité 90 %, taux de faux positifs 10 %) induit souvent des réponses de l'ordre de 90 %. Ces travaux fondent l'usage des fréquences naturelles et des tableaux d'icônes dans la communication en santé.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La littératie en santé, priorité internationale

La **Déclaration de Shanghai** (OMS, 2016), présentée au chapitre 1 avec les autres grandes conférences de promotion de la santé, fait de la littératie en santé l'un de ses **trois piliers**, avec la bonne gouvernance et les villes-santé. Le rapport du bureau régional de l'OMS pour l'Europe *Health literacy: the solid facts* (Kickbusch, Pelikan, Apfel et Tsouros, 2013) synthétise les données européennes et recommande d'agir à la fois sur les **compétences** des personnes et sur la **complexité** des systèmes. En France, la littératie en santé est inscrite dans la stratégie nationale de santé et dans plusieurs projets régionaux de santé ; l'action du diététicien s'inscrit donc dans des orientations publiques identifiables, qu'il peut citer pour justifier un projet.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La « réactivité » des organisations à la littératie

Le concept de *health literacy responsiveness* (Trezona, Dodson et Osborne, 2017) déplace la question : il ne s'agit plus seulement de savoir si une personne a une littératie suffisante, mais si une **organisation** est capable de s'adapter aux besoins de littératie de tous ses usagers. Le cadre décrit plusieurs domaines (engagement de la direction, systèmes et procédures, communication, compétences du personnel, environnement physique, partenariats). Il complète les dix caractéristiques de Brach (2012) et permet de construire des indicateurs d'évaluation au niveau de la structure, et pas uniquement au niveau des participants.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Littératie, numératie et choix alimentaires : ce que montre la recherche

Plusieurs études observent que les personnes ayant une numératie limitée utilisent moins le tableau nutritionnel, se trompent davantage dans le calcul d'une portion et s'appuient plus sur les allégations de façade. Les logos simples et colorés, comme le Nutri-Score, ont été conçus en partie pour réduire cet écart : les essais menés en France (équipe EREN, Hercberg et Julia) ont montré qu'ils sont mieux compris que des repères chiffrés, y compris par les personnes les moins diplômées. La recherche conclut cependant qu'un logo ne suffit pas : l'environnement (prix, offre, publicité) pèse plus lourd que la compréhension seule sur les achats.

5.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Consultation et compréhension

Un patient diabétique de type 2 repart d'une consultation avec un plan alimentaire de 4 pages. Le diététicien réduit à 3 messages prioritaires, utilise l'assiette modèle et des photos de portions, pratique le « faire dire » et remet un support d'une page.

Situation bc2 – Les menus affichés

En restauration collective, le diététicien conçoit un affichage des menus avec pictogrammes (plat végétarien, allergènes, fait maison), lisible par les enfants et par les familles qui maîtrisent peu le français.

Situation bc3 – Atelier « lire une étiquette » à l'épicerie solidaire

Le diététicien anime un atelier avec de vrais emballages : comparaison de deux céréales par le Nutri-Score, repérage du sucre dans la liste d'ingrédients, jeu de tri ; les consignes sont orales et imagées, et l'atelier se termine par un « faire dire ».

Situation bc3 – Une campagne municipale accessible

Une ville prépare une campagne sur les boissons sucrées. Le diététicien propose de tester les affiches auprès de collégiens et de parents, de produire une version FALC et une vidéo sous-titrée, et de relayer par les associations de quartier.

Situation bc2 – Affichage des allergènes

Le diététicien d'une cuisine centrale conçoit un affichage des 14 allergènes par pictogrammes et couleurs, compréhensible par les enfants, les familles allophones et les agents, et le teste auprès de 10 parents.

Situation bc3 – Une campagne « sucres cachés »

Pour une campagne dans des collèges, le diététicien remplace les grammes par des morceaux de sucre réels, présente les risques en fréquences naturelles et fait concevoir les affiches par des élèves.

Méthode 1 – Justifier à l'oral E5 la prise en compte de la littératie dans un projet

À l'oral, le jury demande souvent : « Comment avez-vous adapté votre action à votre public ? » Une réponse vague (« j'ai fait simple ») ne montre pas la compétence. Une réponse structurée en quatre temps, appuyée sur des faits, est beaucoup plus convaincante.

Méthode pas à pas – Répondre en 2 minutes avec la structure « constat, choix, vérification, limite »

1. Le constat (20 secondes) : ce que vous saviez du public, avec une source datée (données HLS19, diagnostic, entretien avec la structure). Exemple : « la référente familles m'a indiqué que la moitié des participantes lisent difficilement le français ».

2. Les choix (50 secondes) : deux ou trois adaptations précises, chacune reliée au constat (supports imagés, consignes orales, vrais aliments, horaires, mode d'inscription).

3. La vérification (30 secondes) : comment vous avez vérifié la compréhension (test du support, « faire dire », indice de lisibilité avant et après, retour des participants).

4. La limite et l'amélioration (20 secondes) : ce qui n'a pas fonctionné et ce que vous changeriez. Le jury apprécie un regard critique honnête.

Exemple – Une réponse structurée (projet fictif)

« **Constat** : l'atelier s'adressait à des résidents d'un foyer de travailleurs migrants ; le directeur m'a indiqué que beaucoup parlent un peu le français mais le lisent peu, et l'enquête HLS19 montre que la littératie limitée est plus fréquente chez les personnes peu diplômées.

Choix : j'ai remplacé la fiche recette écrite par une fiche en six photos numérotées ; j'ai fait les consignes à l'oral en montrant les gestes ; j'ai utilisé des boîtes de conserve réelles pour la lecture des étiquettes, en me limitant au sel.

Vérification : j'ai testé la fiche auprès de trois résidents la semaine précédente, ce qui m'a fait changer deux photos ; en fin d'atelier, chaque participant a montré la boîte la moins salée et expliqué pourquoi.

Limite : deux résidents ne parlaient que le soninké ; la prochaine fois, je prévoirai un résident relais pour la traduction des consignes. »

Attention – Les phrases à éviter devant le jury

- « Mon public avait un faible niveau » : formulation stigmatisante. Préférez « certains participants lisaient difficilement le français ».
- « J'ai testé leur niveau de lecture » : contraire aux précautions universelles, sauf démarche de recherche encadrée et consentie.
- « Le support était adapté » sans preuve : citez un test, un indice ou un retour du public.
- « J'ai traduit avec Google Traduction » sans vérification : un outil automatique ne remplace pas la relecture par une personne qui maîtrise la langue.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.50

Vous avez animé un atelier « petit-déjeuner » dans une école maternelle avec des parents dont plusieurs maîtrisent peu le français écrit. Rédigez votre réponse orale à la question « Comment avez-vous adapté votre action ? » en suivant les quatre temps (environ 10 lignes).

Corrigé – Exercice d'application 5.51

Exemple de réponse : « **Constat** : la directrice m'a signalé que plusieurs parents parlent arabe, turc ou tamoul et lisent peu le français ; les invitations écrites précédentes avaient eu peu de retours. **Choix** : l'invitation a été remise en main propre par les enseignantes, avec un dessin et l'heure en gros chiffres ; pendant l'atelier, j'ai montré de vrais aliments et une assiette modèle, et j'ai limité le message à trois idées ; une maman bilingue a accepté de reformuler les consignes. **Vérification** : à la fin, chaque parent a composé un petit-déjeuner avec les aliments posés sur la table et l'a expliqué à son voisin ; 11 parents sur 13 ont composé un petit-déjeuner conforme aux trois idées. **Limite** : l'atelier avait lieu à 8 h 30, et les parents qui travaillent n'ont pas pu venir ; je proposerais une deuxième séance en fin de journée. »

Le corrigé n'est qu'un exemple : l'essentiel est que chaque adaptation réponde à un constat et que la compréhension soit vérifiée.

Méthode 2 – Analyser un support dans une question écrite de l'épreuve

Les sujets E5 présentent souvent un document (affiche, dépliant, page web, menu) et demandent : « Analysez ce support au regard de la littératie en santé et proposez des améliorations. » La méthode ci-dessous évite d'oublier des critères et donne une réponse organisée.

Méthode pas à pas – Analyser un support en cinq critères

1. Le public et l'objectif : à qui s'adresse le support, et que doit faire la personne après l'avoir lu ?

2. Le texte : longueur des phrases, mots difficiles, sigles, chiffres, formulations négatives ; si possible, un indice de lisibilité calculé sur un extrait.

3. La mise en page : taille des caractères, contraste, hiérarchie (titre, message principal), place des images, espaces.

4. Les images et les chiffres : images utiles ou décoratives, pictogrammes compréhensibles, chiffres présentés en fréquences ou en mesures ménagères.

5. L'accès et l'action : où le support est-il diffusé, existe-t-il en version orale, traduite ou numérique accessible ; l'action demandée est-elle possible (coût, lieu, horaires) ?

Pour chaque critère, on écrit **un point fort ou une faiblesse observée dans le document**, puis **une amélioration précise**. On termine par la manière de tester la nouvelle version auprès du public.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.52

Une mairie distribue ce texte imprimé en police 9, en gris clair sur fond blanc, sans image : « Dans le cadre du PNNS et du PAT, la Ville organise, sous réserve d'un nombre suffisant d'inscrits, des ateliers nutritionnels non obligatoires visant l'amélioration de la qualité nutritionnelle de l'alimentation des ménages. Inscriptions exclusivement sur le portail citoyen avant le 15/03. »

Analysez ce support avec les cinq critères et proposez une nouvelle version.

Corrigé – Exercice d'application 5.53

1. Public et objectif : le public n'est pas nommé et l'action attendue (s'inscrire) arrive à la fin. Amélioration : commencer par l'invitation.

2. Texte : deux phrases longues, deux sigles (PNNS, PAT), une négation (« non obligatoires »), des mots abstraits (« qualité nutritionnelle de l'alimentation des ménages »). Amélioration : phrases courtes, mots courants, sigles supprimés.

3. Mise en page : police 9 et gris clair, contraste insuffisant. Amélioration : police d'au moins 12 à 14 points, texte noir ou très foncé, titre en gras.

4. Images : aucune. Amélioration : une photo d'un atelier ou d'un plat, un pictogramme pour la date et le lieu.

5. Accès et action : inscription uniquement en ligne, ce qui exclut une partie du public. Amélioration : inscription aussi par téléphone et à l'accueil de la mairie ou du centre social.

Nouvelle version : « Venez cuisiner avec nous ! Ateliers cuisine gratuits pour toute la famille. Où : centre social, 12 rue des Écoles. Quand : les mercredis de 14 h à 16 h. Pour vous inscrire : à l'accueil de la mairie, par téléphone au (numéro) ou sur le site de la ville. Avant le 15 mars. » La version est ensuite testée auprès de cinq habitants.

Méthode 3 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve

À vous de jouer – Vrai ou faux commentés

Pour chaque affirmation, dites si elle est vraie ou fausse et justifiez en une phrase.

1. « La littératie en santé, c'est savoir lire. »
2. « Une personne diplômée a forcément une bonne littératie en santé. »
3. « Les précautions universelles consistent à communiquer clairement avec tout le monde. »
4. « Il faut demander aux participants leur niveau de lecture au début d'un atelier. »
5. « Un indice de Flesch élevé signifie que le texte est difficile. »
6. « Un bon indice de lisibilité suffit pour valider un support. »
7. « Le FALC peut être rédigé seul par un professionnel, sans relecture. »
8. « Demander "Avez-vous compris ?" permet de vérifier la compréhension. »
9. « Le "faire dire" teste la mémoire du patient. »
10. « Un risque qui passe de 2 sur 1 000 à 1 sur 1 000 diminue de 50 %. »
11. « Faire traduire un entretien de santé par l'enfant de la famille est une bonne solution. »
12. « Le Nutri-Score permet de comparer des produits d'une même catégorie. »
13. « Mettre tout le texte en majuscules le rend plus lisible. »
14. « La littératie critique permet d'agir collectivement sur son environnement. »
15. « Agir sur la littératie, c'est seulement former les personnes. »

Corrigé – Vrai ou faux commentés

1. **Faux.** Elle comprend l'accès, la compréhension, l'évaluation et l'application de l'information de santé (Sørensen, 2012), à l'écrit comme à l'oral et en ligne.
2. **Faux.** La littératie dépend aussi de la situation : une personne diplômée peut être en difficulté face à un diagnostic grave, au stress ou à un vocabulaire médical inhabituel.
3. **Vrai.** On ne peut pas savoir qui a des difficultés ; on adapte donc la communication pour tous, sans repérage stigmatisant.
4. **Faux.** C'est stigmatisant et contraire aux précautions universelles ; la honte peut éloigner les personnes de l'atelier.
5. **Faux.** C'est l'inverse : plus l'indice de Flesch (ou de Kandel et Moles) est élevé, plus le texte est facile à lire.

6. **Faux.** L'indice ne mesure ni le sens des mots, ni les images, ni la mise en page ; seul un test auprès du public montre la compréhension.
7. **Faux.** Les règles européennes du FALC prévoient la participation de personnes en situation de handicap intellectuel à la rédaction ou à la relecture.
8. **Faux.** La plupart des personnes répondent « oui » par politesse ou par gêne ; il faut demander de reformuler ou de montrer.
9. **Faux.** Il teste la **clarté des explications du professionnel** : si la personne ne sait pas reformuler, c'est l'explication qu'il faut reprendre.
10. **Vrai**, en risque relatif ; mais la diminution absolue n'est que de 1 sur 1 000. Il faut présenter les deux, de préférence en fréquences naturelles.
11. **Faux.** L'enfant n'a ni la neutralité ni le vocabulaire d'un interprète, et le rôle inverse sa place dans la famille ; on fait appel à un interprète professionnel.
12. **Vrai.** Il est surtout utile pour comparer des produits comparables (des céréales entre elles, par exemple) ; il ne dit pas s'il faut manger un aliment ni en quelle quantité.
13. **Faux.** Les majuscules ralentissent la lecture, car les mots perdent leur forme ; on les réserve à quelques mots courts.
14. **Vrai.** Selon Nutbeam, la littératie critique permet d'analyser l'information et d'agir, seul ou en groupe, sur les déterminants de la santé.
15. **Faux.** Il faut aussi simplifier l'environnement : documents, démarches, signalétique, formation des professionnels (organisations « amies de la littératie »).

Méthode 4 – Relier la littératie aux autres chapitres du cours

La littératie n'est pas une notion isolée : à l'épreuve, elle se combine presque toujours avec d'autres parties du programme. Le tableau ci-dessous aide à faire ces liens sans répéter les contenus.

Notion du chapitre 5	Lien avec	Ce que l'on mobilise
Gradient social de la littératie	Chapitre 2 (inégalités sociales de santé)	Universalisme proportionné, lentille inégalités
Précautions universelles, honte	Chapitre 3 (psychologie sociale)	Estime de soi, stigmatisation, influence des pairs
Littératie alimentaire	Chapitre 4 (pratiques alimentaires)	Stratégies des ménages modestes, cultures culinaires
Respect de la personne, interprétariat	Chapitre 6 (éthique)	Autonomie, consentement, secret
Littératie à chaque étape du projet	Chapitres 7 à 9 (démarche de projet)	Diagnostic participatif, objectifs, évaluation
Atelier accessible	Chapitre 10 (atelier culinaire)	Fiches recettes imagées, consignes orales
Supports écrits et numériques	Chapitres 14 et 15 (communication)	Choix du canal, conception graphique, accessibilité
Numératie, risques	Chapitre 16 (épidémiologie)	Risques relatifs et absolus, fréquences
Fiabilité de l'information	Chapitre 19 (veille et lecture critique)	Sources, niveau de preuve
IA, données, accessibilité numérique	Chapitre 20 (numérique en santé)	RGPD, responsabilité, outils

À vous de jouer – Exercice d'application 5.54

Un sujet E5 présente un projet de « défi cuisine » dans un quartier prioritaire, avec inscription en ligne et livret de recettes de 20 pages. Citez trois chapitres du cours que vous mobiliseriez en plus du chapitre 5 et

indiquez pour chacun l'idée principale.

Corrigé – Exercice d'application 5.55

Exemples : **chapitre 2**, l'inscription en ligne et le livret long risquent de creuser les inégalités, d'où des modalités adaptées aux habitants les plus éloignés ; **chapitre 7**, associer les habitants au diagnostic et à la conception du défi ; **chapitre 15**, transformer le livret en fiches recettes courtes et imagées, testées auprès du public ; **chapitre 10**, prévoir des recettes réalisables avec un petit équipement et un petit budget. Trois liens justifiés suffisent.

5.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Définitions et données

- **Littératie en santé** (Sørensen, 2012) : connaissances, motivation et compétences pour **accéder, comprendre, évaluer, appliquer** l'information, dans les domaines des **soins**, de la **prévention** et de la **promotion de la santé** (12 dimensions).
- **Niveaux** (Nutbeam, 2000) : **fonctionnel** (lire, comprendre), **interactif** (échanger), **critique** (juger, agir).
- **Littératie alimentaire** : planifier et gérer, sélectionner, préparer, manger (Vidgen et Gallegos, 2014).
- **France (HLS19, 2021)** : environ **44 %** des adultes ont une littératie limitée ; difficultés encore plus fréquentes en **numérique** ; **gradient social**.
- **Illettrisme** 7 % des 18-65 ans (ANLCI, 2011) ; **illectronisme** 7 % des 16-74 ans en 2025 (Insee, 2026) ; faible maîtrise de l'écrit 28 % des 16-65 ans (PIAAC 2023).
- Conséquences : moins de prévention, plus d'hospitalisations, moins bonne gestion des maladies chroniques ; **creusement des inégalités** si la communication n'est pas adaptée.

À retenir – Pratique professionnelle

- **Précautions universelles** : communiquer clairement avec tous, sans tester ni stigmatiser.
- **Écrire simple** : une idée par phrase, mots courants, forme active et positive, chiffres concrets, pictogrammes, mise en page aérée ; **FALC** ; tester les supports.
- **Lisibilité** : L = 207 − 1,015 × (mots/phrase) − 73,6 × (syllabes/mot).
- **Faire dire** (HAS, 2015) : expliquer → faire reformuler → vérifier → réexpliquer autrement → confirmer.
- **Plusieurs canaux** : oral, imagé, numérique accompagné, médiation, relais.

À retenir – Compléments : étiquettes, numératie, numérique, allophonie

- **Étiquette** (règlement INCO 1169/2011) : dénomination, ingrédients (ordre décroissant, 14 allergènes), Nutri-Score (comparer dans une même famille ; algorithme révisé), tableau pour 100 g et par portion, dates, prix au kilo.
- **Sucres** : g pour 100 mL × volume / 100 ; un morceau ≈ 5 g ; OMS : sucres libres < 10 % de l'énergie (≈ 50 g pour 2 000 kcal).
- **Numératie** : fréquences naturelles (« 6 sur 100 ») ; tableaux d'icônes ; donner la réduction **absolue** et **relative**.
- **Numérique** : évaluer une application (éditeur, fondement, mise à jour, données, accessibilité, effets indésirables) ; RGAA / WCAG ; texte alternatif, sous-titres.
- **Allophones** : interprétariat professionnel, médiateurs, supports testés, pictogrammes ; pas d'enfants

interprètes.

- **Tester** : l'indice de lisibilité ne remplace pas le test de compréhension auprès du public.

5.8 Entraînement

5.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Selon Sørensen (2012), les quatre compétences de la littératie en santé sont :

a) accéder **b)** mémoriser **c)** évaluer **d)** appliquer

QCM 2 – Les trois domaines du modèle de Sørensen sont :

a) les soins **b)** la prévention **c)** la promotion de la santé **d)** la recherche

QCM 3 – La littératie critique (Nutbeam) correspond à :

a) savoir lire une étiquette **b)** juger la fiabilité d'une information et agir sur ses déterminants **c)** échanger avec un professionnel **d)** le niveau le plus élevé d'autonomie

QCM 4 – D'après HLS19, la part des adultes en France ayant une littératie en santé limitée est d'environ :

a) 7 % **b)** 15 % **c)** 44 % **d)** 90 %

QCM 5 – L'illettrisme concerne des personnes :

a) jamais scolarisées **b)** scolarisées en France sans maîtrise suffisante de l'écrit **c)** apprenant le français comme langue étrangère **d)** environ 7 % des 18-65 ans en 2011

QCM 6 – L'approche des précautions universelles consiste à :

a) tester le niveau de lecture de chaque participant **b)** communiquer clairement avec tout le monde **c)** éviter de désigner les personnes en difficulté **d)** réserver les supports simplifiés aux personnes illettrées

QCM 7 – La technique du « faire dire » :

a) consiste à demander « Vous avez compris ? » **b)** fait reformuler la personne avec ses mots **c)** vérifie la clarté du professionnel **d)** a fait l'objet d'une fiche-outil de la HAS

QCM 8 – Parmi ces règles d'écriture claire, lesquelles sont correctes ?

a) une idée par phrase **b)** utiliser des sigles pour gagner de la place **c)** préférer la forme active **d)** écrire en majuscules pour être lisible

QCM 9 – Le FALC :

a) signifie « facile à lire et à comprendre » **b)** repose sur des règles européennes **c)** implique une relecture par des personnes concernées **d)** est réservé aux enfants

QCM 10 – Dans l'indice de Kandel et Moles, la lisibilité augmente quand :

a) les phrases sont plus courtes **b)** les mots ont moins de syllabes **c)** le texte est plus long **d)** le texte contient plus de sigles

QCM 11 – La littératie alimentaire comprend :

a) planifier et gérer **b)** sélectionner **c)** préparer **d)** manger

QCM 12 – Une littératie en santé limitée est associée à :

a) un moindre recours à la prévention **b)** davantage d'hospitalisations **c)** une meilleure observance **d)** un creusement des inégalités sociales de santé

QCM 13 – L'illectronisme :

a) concerne environ 7 % des 16-74 ans (Insee, 2025) **b)** est sans effet sur l'accès à la prévention **c)** justifie de ne pas réserver une inscription au numérique **d)** désigne une maladie de la vue

QCM 14 – La médiation en santé :

a) est inscrite dans le Code de la santé publique **b)** a fait l'objet d'un référentiel de la HAS en 2017 **c)** remplace le diététicien **d)** facilite le lien entre publics éloignés et professionnels

QCM 15 – Le Nutri-Score :

a) a été conçu pour être compris par le plus grand nombre **b)** remplace la liste d'ingrédients **c)** permet de comparer des produits d'une même famille **d)** n'a aucun lien avec la littératie

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, c, d (+ comprendre). 2. **a, b, c**. 3. **b, d**. 4. **c**. 5. **b, d** (a = analphabétisme ; c = FLE). 6. **b, c**. 7. **b, c, d** (a est justement à éviter). 8. **a, c**. 9. **a, b, c**. 10. **a, b**. 11. **a, b, c, d**. 12. **a, b, d**. 13. **a, c**. 14. **a, b, d**. 15. **a, c**.

QCM 16 – Dans la liste des ingrédients :

a) les ingrédients sont classés par ordre décroissant de poids **b)** les allergènes sont mis en évidence **c)** le premier ingrédient est le moins abondant **d)** le classement est libre

QCM 17 – Une boisson à 10 g de sucres pour 100 mL, en bouteille de 50 cL, contient environ :

a) 10 g de sucres **b)** 50 g de sucres **c)** 10 morceaux de sucre **d)** 2 morceaux de sucre

QCM 18 – Un risque qui passe de 4 sur 100 à 2 sur 100 correspond à :

a) une réduction absolue de 2 points **b)** une réduction relative de 50 % **c)** une réduction relative de 2 % **d)** une réduction absolue de 50 %

QCM 19 – Pour rendre une vidéo de prévention accessible, on ajoute :

a) des sous-titres **b)** une musique forte **c)** une version audio-décrite ou un texte explicatif **d)** un texte alternatif aux images de la page

QCM 20 – Le Nutri-Score permet de :

a) comparer des produits d'une même famille **b)** comparer une pizza et une pomme **c)** remplacer la liste des ingrédients **d)** mesurer le degré de transformation

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM complémentaires

16. a, b. 17. **b, c** (10 × 500 / 100 = 50 g ; 50 / 5 = 10 morceaux). 18. **a, b**. 19. **a, c, d**. 20. **a**.

5.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : le modèle de Sørensen

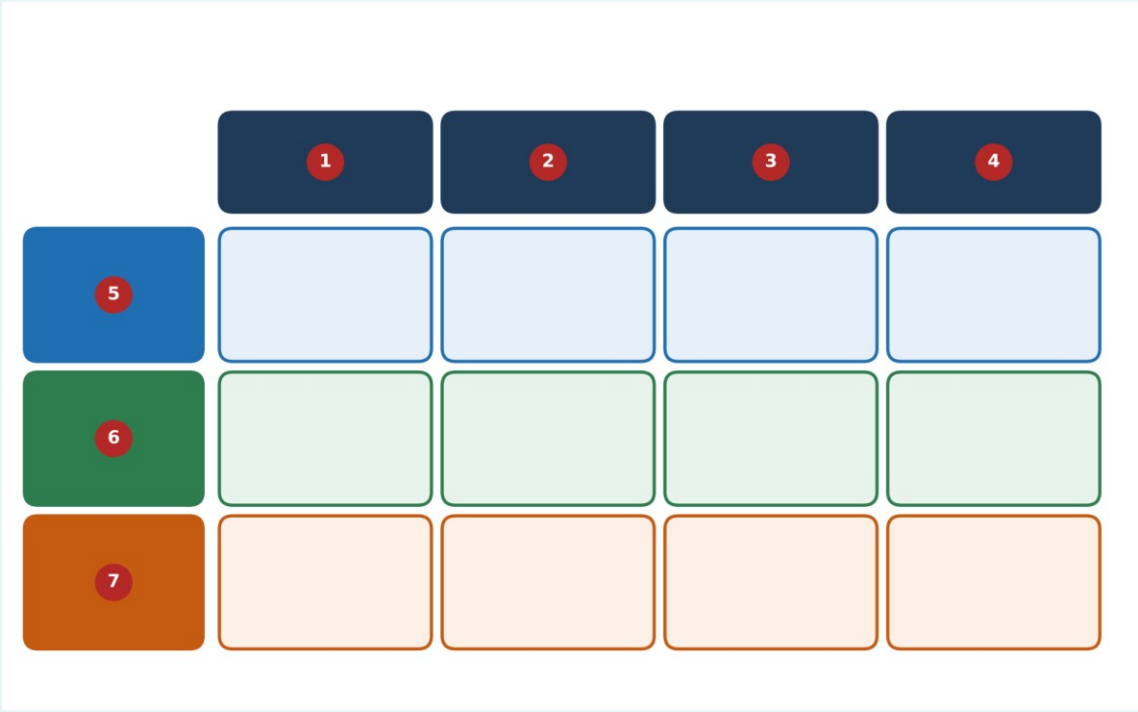


Figure 5.9 – Schéma à légender

Légendez les colonnes 1 à 4 et les lignes 5 à 7, puis complétez trois cases avec un exemple alimentaire.

Corrigé

1. Accéder. 2. Comprendre. 3. Évaluer. 4. Appliquer. 5. Soins. 6. Prévention. 7. Promotion de la santé. Exemples : *prévention × comprendre* : comprendre le Nutri-Score ; *prévention × évaluer* : juger un conseil minceur sur un réseau social ; *promotion × accéder* : connaître l'épicerie solidaire du quartier.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : les niveaux de Nutbeam

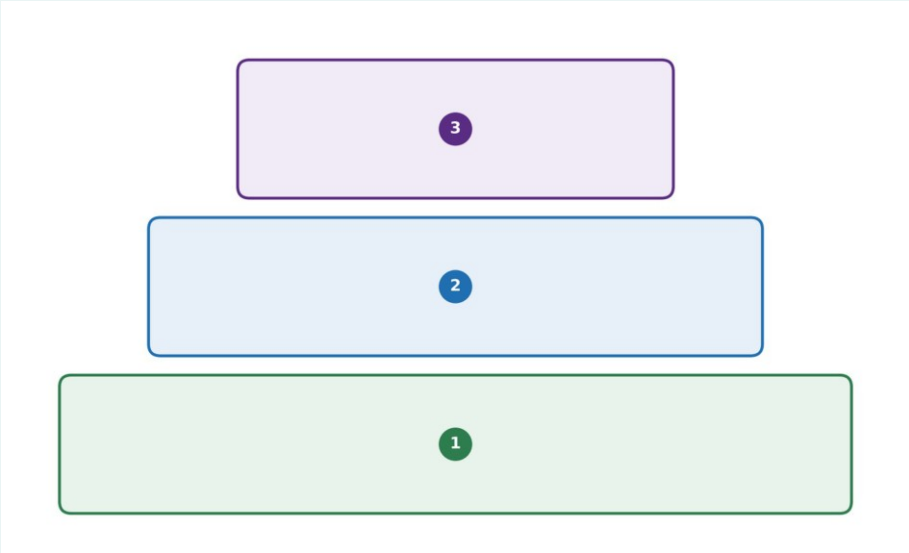


Figure 5.10 – Schéma à légender

Nommez les niveaux 1 à 3 et associez chacune des situations suivantes à un niveau : a) Mme K. lit la date limite sur un yaourt ; b) M. T. demande au diététicien si les conseils s'appliquent à son travail de nuit ; c) un collectif de parents obtient de l'eau en carafe à la cantine.

Corrigé

1. Fonctionnelle – a. 2. **Interactive** – b. 3. **Critique** – c (action collective sur un déterminant).

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : le faire dire

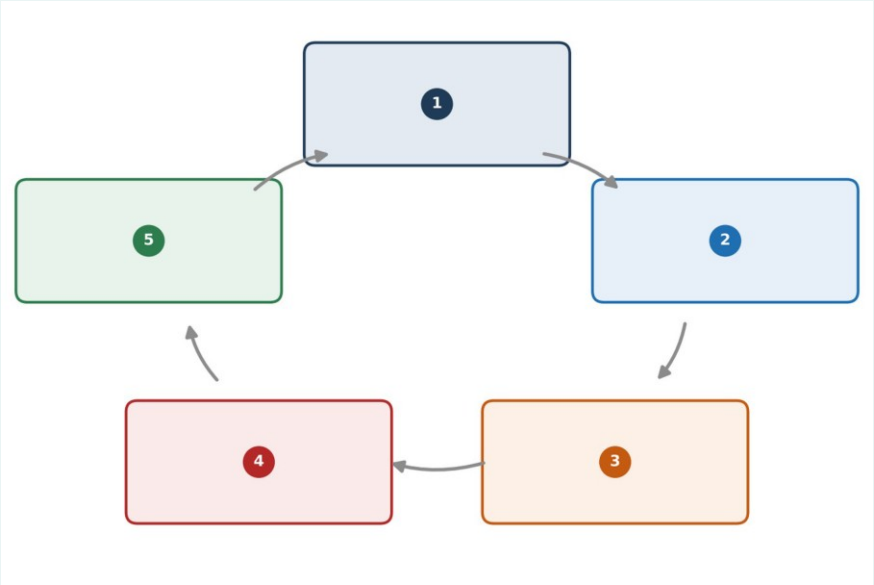


Figure 5.11 – Schéma à légender

Légendez les étapes 1 à 5 et rédigez la phrase que vous utiliseriez à l'étape 2 après un atelier sur la lecture des étiquettes.

Corrigé

1. Expliquer. 2. Faire dire. 3. Vérifier. 4. Réexpliquer autrement. 5. Confirmer. Phrase : « Pour vérifier que j'ai bien expliqué : montrez-moi, avec ces deux paquets de biscuits, lequel vous choisiriez et pourquoi. »

À vous de jouer – Exercice 4 – Calculer un indice de lisibilité

Un texte de prévention compte 150 mots, 6 phrases et 255 syllabes. a) Calculez l'indice de Kandel et Moles et interprétez. b) Après réécriture : 140 mots, 14 phrases, 210 syllabes. Recalculez et concluez.

Corrigé

a) Mots/phrase = 150 / 6 = **25** ; syllabes/mot = 255 / 150 = **1,7**. L = 207 − 1,015 × 25 − 73,6 × 1,7 = 207 − 25,375 − 125,12 = **56,505 ≈ 56,5** → assez difficile. **b)** Mots/phrase = 140 / 14 = **10** ; syllabes/mot = 210 / 140 = **1,5**. L = 207 − 1,015 × 10 − 73,6 × 1,5 = 207 − 10,15 − 110,4 = **86,45** → facile. Gain : 86,45 − 56,505 = **29,9 points**. L'indice confirme l'amélioration, mais le texte doit encore être **testé** auprès du public.

À vous de jouer – Exercice 5 – Réécrire un message

Réécrivez en langage clair : « La consommation de légumineuses, sources de protéines végétales et de fibres, doit être augmentée à au moins deux fois par semaine conformément aux recommandations nutritionnelles en vigueur. »

Corrigé

« Mangez des lentilles, des pois chiches ou des haricots secs au moins 2 fois par semaine. Ils nourrissent bien et coûtent peu cher. » + photos des trois aliments + un exemple de plat (dahl, chili, salade de lentilles). Les mots « légumineuses », « protéines végétales » et « recommandations en vigueur » ont été remplacés par des exemples concrets.

À vous de jouer – Exercice 6 – Analyser un support existant

Une affiche d'atelier comporte : un titre « Programme d'éducation nutritionnelle PNNS – Session 2 », un texte justifié de 12 lignes en police 10, une photo décorative de salade, une inscription par QR code uniquement. Relevez les problèmes et proposez des corrections.

Corrigé

Problèmes : sigle (PNNS), titre abstrait qui ne dit pas ce qu'on va faire ; texte long, justifié, police trop petite ; image décorative sans information ; inscription uniquement numérique (exclusion des personnes en illectronisme). Corrections : titre concret « Cuisinons ensemble des repas pas chers » ; 3 informations (quand, où, gratuit) en gros caractères avec pictogrammes (horloge, lieu, euro barré) ; photo de participants en train de cuisiner ; inscription à l'accueil, par téléphone **ou** par QR code.

À vous de jouer – Exercice 7 – Interpréter des données

Dans un questionnaire de diagnostic rempli par 60 personnes d'une épicerie solidaire, 27 déclarent qu'il leur est « difficile » ou « très difficile » de comprendre les informations sur les emballages, et 42 n'ont jamais utilisé le site *mangerbouger.fr*. Calculez les pourcentages et proposez deux conséquences pour l'action.

Corrigé

27 / 60 × 100 = **45 %** ont des difficultés avec les emballages (proche de l'ordre de grandeur national de HLS19, 44 %) ; 42 / 60 × 100 = **70 %** n'utilisent pas le site. Conséquences : atelier pratique avec de vrais emballages (compétence « comprendre » et « évaluer ») ; supports papier et oraux plutôt qu'un renvoi au site, ou accompagnement à son utilisation sur smartphone.

À vous de jouer – Exercice 8 – Recette en images

Transformez la recette suivante en fiche accessible : « Faire revenir 1 oignon émincé dans 1 c. à s. d'huile, ajouter 200 g de lentilles corail rincées, 400 g de tomates concassées et 600 mL d'eau, cuire 15 min, assaisonner de cumin. »

Corrigé

Titre : **Soupe de lentilles corail** (4 personnes, 20 minutes, environ 2 €). Étape 1 (photo) : Coupez 1 oignon en petits morceaux. Étape 2 : Faites cuire l'oignon avec 1 cuillère à soupe d'huile, 3 minutes. Étape 3 : Lavez 1 grand verre de lentilles corail (200 g) dans une passoire. Étape 4 : Mettez les lentilles, 1 boîte de tomates et 3 verres d'eau (600 mL avec un verre de 200 mL). Étape 5 : Faites cuire 15 minutes. Étape 6 : Ajoutez 1 pincée de cumin et de sel. Chaque étape a une photo, une seule action, un verbe d'action au début.

À vous de jouer – Exercice 9 – Juger une information en ligne

Une vidéo d'un influenceur affirme : « Le jus de citron à jeun fait fondre les graisses : -5 kg en 2 semaines ! » Appliquez la grille des 6 questions.

Corrigé

Auteur : influenceur sans qualification en santé identifiée ; objectif : souvent commercial (lien vers une cure) ; sources : aucune étude citée ; date : non pertinente ici ; cohérence : contraire aux connaissances (aucun aliment ne « fait fondre » les graisses) ; promesse miraculeuse et rapide : **signal d'alerte**. Conclusion : information non fiable ; c'est un bon support pour un atelier de littératie critique.

À vous de jouer – Exercice 10 – Questionnaire accessible

Transformez la question suivante pour des enfants de 8 ans : « Évaluez votre niveau de satisfaction concernant l'atelier sur une échelle de 1 à 10. »

Corrigé

« As-tu aimé l'atelier ? » avec trois ou cinq visages (très content, content, moyen, pas content, pas du tout content) à entourer ou une gommette à coller ; question complémentaire orale : « Qu'est-ce que tu as préféré ? ».

5.8.3 Questions de réflexion

À vous de jouer – Question 1

Pourquoi dit-on que la littératie en santé est aussi une responsabilité des professionnels et des organisations ?

Corrigé

Parce que la difficulté naît de la **rencontre** entre les compétences d'une personne et la complexité de l'information et des services. Simplifier les documents, former les professionnels, proposer plusieurs canaux réduit les difficultés pour tous, sans faire porter l'effort sur les seules personnes (littératie organisationnelle). C'est aussi une question d'équité.

À vous de jouer – Question 2

Une campagne de prévention diffusée uniquement sur les réseaux sociaux peut-elle accroître les inégalités ?

Corrigé

Oui : les personnes les plus favorisées ont plus d'accès et de compétences numériques et critiques ; elles s'approprient mieux les messages. Les personnes en illectronisme ou à littératie limitée sont moins touchées. D'où l'universalisme proportionné : diffusion large **et** actions de proximité adaptées (ateliers, relais, médiation).

À vous de jouer – Question 3

Simplifier un message, est-ce le rendre moins exact ?

Corrigé

Non, si on choisit l'**essentiel** et qu'on le formule concrètement : « 5 fruits et légumes par jour » est simple et exact. Le risque est de simplifier jusqu'à l'erreur (« le gras, c'est mauvais ») ; on garde donc la validation scientifique du fond (repères officiels) et on adapte la forme. La simplification est un travail exigeant, pas un appauvrissement.

5.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – Le foyer de travailleurs migrants

Un foyer de travailleurs migrants (180 résidents, âge moyen 58 ans) souhaite une action sur le diabète et l'alimentation. Une partie des résidents lit peu le français ; beaucoup cuisinent collectivement dans les cuisines d'étage ; le gestionnaire propose de « distribuer la brochure de l'Assurance maladie ».

1. Analysez les enjeux de littératie (domaines et niveaux).
2. Pourquoi la brochure seule est-elle insuffisante ?
3. Proposez une action adaptée (supports, méthodes, partenaires).
4. Comment vérifier la compréhension ?
5. Proposez deux indicateurs d'évaluation accessibles.

Corrigé

1. Domaines : **prévention** (dépistage du diabète), **soins** (comprendre un traitement) ; niveaux fonctionnel (lecture) et interactif (échanger avec un soignant) ; facteurs : langue, âge, culture culinaire, cuisine collective.
2. Elle repose sur l'écrit en français, est générale, ne tient pas compte des plats cuisinés au foyer ni des pratiques (Ramadan, plats communautaires).
3. Groupe de parole et atelier culinaire dans la cuisine d'étage, avec un **médiateur en santé** ou un résident relais parlant les langues du groupe ; supports imagés (assiette, portions de riz et de semoule en photos) ; travail sur les plats habituels (mafé, riz au poisson) pour ajuster les portions de féculents et ajouter des légumes ; partenariat avec la CPAM ou un centre d'examens de santé pour un dépistage, la PASS ou le centre de santé pour l'orientation.
4. Faire dire en petit groupe (« Montrez-moi la quantité de riz pour une assiette »), démonstrations, questions ouvertes, avec traduction.
5. Nombre de résidents ayant participé et ayant réalisé un dépistage ; proportion de participants capables de montrer la portion conseillée en fin de séance (observation).

5.8.5 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Donnez une définition de la littératie en santé. »

Corrigé

Ce sont les connaissances, la motivation et les compétences pour accéder, comprendre, évaluer et appliquer l'information en santé, dans les soins, la prévention et la promotion de la santé (Sørensen, 2012).

Mise en situation – MSE 2

Une participante dit : « J'ai oublié mes lunettes, je remplirai le questionnaire chez moi. »

Corrigé

Je ne mets pas la personne en difficulté : je propose de lui poser les questions oralement (« Je peux vous les lire, ça ira plus vite ») et je note les réponses ; à l'avenir, je proposerai l'oral à tout le groupe.

Mise en situation – MSE 3

Le jury : « Pourquoi ne pas demander "Vous avez compris ?" »

Corrigé

Parce que la réponse est presque toujours « oui », par politesse ou par gêne ; je préfère le faire dire : faire reformuler ou montrer, ce qui vérifie vraiment ma clarté.

Mise en situation – MSE 4

Votre tutrice vous demande une affiche pour un atelier ; vous avez 30 minutes.

Corrigé

Un titre concret, trois informations (quoi, quand, où) en gros caractères, des pictogrammes, une photo réelle, une inscription possible à l'accueil ; je la fais relire par deux personnes du public avant impression.

Mise en situation – MSE 5

Le jury : « Quel chiffre retenez-vous sur la littératie en France ? »

Corrigé

Environ 44 % des adultes ont une littératie en santé limitée (HLS19, résultats 2021), avec des difficultés plus fréquentes pour les informations numériques et un gradient social marqué.

Mise en situation – MSE 6

Un parent ne parle pas français et vient à l'atelier avec son enfant de 10 ans qui traduit.

Corrigé

J'accueille le parent, je privilégie la démonstration et les images ; je ne fais pas porter à l'enfant des informations de santé complexes ou intimes ; je recherche un interprète ou un adulte relais (médiatrice) pour les séances suivantes.

Mise en situation – MSE 7

Le jury : « Qu'est-ce que le FALC ? »

Corrigé

Le « facile à lire et à comprendre » : une méthode de rédaction fondée sur des règles européennes (Inclusion Europe, 2009), conçue avec des personnes en situation de handicap intellectuel, et validée par des relecteurs

concernés.

Mise en situation – MSE 8

Un participant affirme : « J'ai vu sur internet que le gluten est un poison. »

Corrigé

Je l'écoute, puis on applique ensemble la grille de fiabilité (qui ? quel objectif ? quelles sources ?) ; j'explique que l'éviction du gluten ne se justifie qu'en cas de maladie cœliaque ou d'allergie diagnostiquée ; j'en fais un exemple de littératie critique pour le groupe.

Mise en situation – MSE 9

Le jury : « Comment avez-vous pris en compte la littératie dans votre projet ? »

Corrigé

À chaque étape : diagnostic oral, objectifs de compétences, supports testés et imagés, méthodes actives et faire dire, communication multicanale, évaluation par smileys et questions orales ; j'illustre par un exemple précis et un chiffre (par exemple, l'indice de lisibilité avant et après).

Mise en situation – MSE 10

La mairie veut lancer une application de recettes pour les familles du quartier.

Corrigé

Je salue l'idée mais je rappelle l'illectronisme (7 % des 16-74 ans en 2025, et 34 % en difficulté numérique) : je propose de l'associer à des ateliers d'accompagnement, à une version papier des recettes et à des relais humains, et de tester l'application avec des habitants.

Mise en situation – MSE 11

Le jury : « Faut-il faire passer un test de lecture aux participants ? »

Corrigé

Non : cela stigmatise et n'est pas nécessaire ; j'applique les précautions universelles en communiquant clairement avec tout le monde, et j'observe les besoins pour ajuster.

Mise en situation – MSE 12

Une collègue propose de traduire l'affiche avec un traducteur automatique.

Corrigé

Je propose plutôt une traduction relue par une personne qui parle la langue (médiatrice, habitant relais), car une erreur dans un message de santé peut être grave ; et je privilégie les pictogrammes et la transmission orale.

5.8.6 Exercices complémentaires

À vous de jouer – Exercice 11 – Sucres en morceaux

Calculez en grammes et en morceaux de sucre (5 g) : a) un soda à 10,6 g/100 mL, canette de 33 cL ; b) un yaourt aromatisé de 125 g à 12 g/100 g ; c) une compote « sans sucres ajoutés » à 12,5 g/100 g, gourde de 90 g. Commentez c.

Corrigé

a) 10,6 × 3,3 = **35,0 g**, soit **7 morceaux**. b) 12 × 1,25 = **15 g**, soit **3 morceaux**. c) 12,5 × 0,9 = **11,25 g**, soit **2,25 morceaux** : « sans sucres ajoutés » ne veut pas dire « sans sucres » : ce sont les sucres naturellement présents dans les fruits (moins préoccupants que les sucres libres d'un soda, mais à connaître).

À vous de jouer – Exercice 12 – Fréquences naturelles

Reformulez en fréquences naturelles et donnez les réductions absolue et relative : « Manger des fruits et légumes chaque jour réduit le risque de ce problème de 0,8 % à 0,6 %. »

Corrigé

« Sur 1 000 personnes, 8 auraient ce problème sans fruits et légumes quotidiens, et 6 avec. » Réduction absolue : 8 − 6 = **2 personnes sur 1 000** (0,2 point) ; relative : 2 / 8 × 100 = **25 %**.

À vous de jouer – Exercice 13 – Évaluer une application

Une famille utilise une application qui note les produits de 0 à 100 et colore en rouge tous les produits contenant un additif. Appliquez la grille d'évaluation et donnez un conseil.

Corrigé

Éditeur et financement : à vérifier (société privée, modèle économique) ; fondement : algorithme propre, différent du Nutri-Score officiel, qui pénalise fortement les additifs ; mise à jour : variable ; données personnelles : vérifier les autorisations ; effets indésirables possibles : peur de tous les additifs, exclusion de produits utiles (conserves de légumes), culpabilisation. Conseil : l'utiliser comme une information parmi d'autres, se référer au Nutri-Score pour la qualité nutritionnelle et privilégier les produits peu transformés, sans s'inquiéter de chaque additif.

À vous de jouer – Exercice 14 – Lisibilité et test

Une fiche passe de 180 mots en 8 phrases (300 syllabes) à 120 mots en 15 phrases (180 syllabes). Calculez les deux indices. Au test, 4 personnes sur 10 comprennent la version 1 et 8 sur 10 la version 2. Concluez.

Corrigé

V1 : 180 / 8 = 22,5 mots par phrase ; 300 / 180 = 1,667 syllabe par mot ; L = 207 − 1,015 × 22,5 − 73,6 × 1,667 = 207 − 22,84 − 122,69 = **61,47** (standard). V2 : 120 / 15 = 8 ; 180 / 120 = 1,5 ; L = 207 − 8,12 − 110,4 = **88,48** (facile). Compréhension : **40 %** → **80 %**. Les deux mesures convergent ; c'est le test qui démontre la compréhension.

À vous de jouer – Exercice 15 – Adapter pour un public allophone

Un atelier réunit 10 participantes dont 4 parlent peu le français (2 en arabe, 2 en tamoul). Proposez 5 adaptations.

Corrigé

Interprète professionnel ou médiatrice pour l'accueil et les consignes de sécurité ; démonstration avant chaque étape ; recette en photos, quantités en contenants ; pictogrammes des allergènes ; binômes associant une participante francophone et une non francophone ; vocabulaire culinaire illustré à emporter ; vérification par « montrez-moi » plutôt que par questions verbales.

5.9 Glossaire

Terme	Définition
Analphabétisme	Situation de personnes jamais scolarisées, n'ayant pas appris à lire et à écrire
FALC	Facile à lire et à comprendre : méthode de rédaction fondée sur des règles européennes (2009), avec relecture par des personnes concernées
Faire dire (teach-back)	Technique qui fait reformuler la personne pour vérifier la clarté du professionnel
HLS19	Enquête européenne sur la littératie en santé (réseau M-POHL, OMS Europe), 2019-2021
Illectronisme	Difficulté ou incapacité à utiliser les outils numériques et internet
Illettrisme	Maîtrise insuffisante de l'écrit et du calcul chez des personnes scolarisées en France
Indice de lisibilité	Estimation de la difficulté d'un texte à partir de la longueur des phrases et des mots
Littératie alimentaire	Compétences pour planifier, sélectionner, préparer et manger des aliments
Littératie critique	Capacité à juger l'information et à agir sur les déterminants de sa santé
Littératie en santé	Connaissances, motivation et compétences pour accéder, comprendre, évaluer et appliquer l'information en santé
Littératie fonctionnelle	Compétences de base en lecture, écriture et calcul
Littératie interactive	Capacité à échanger et à extraire l'information d'une communication
Littératie numérique en santé	Capacité à trouver, comprendre, évaluer et utiliser l'information de santé en ligne
Littératie organisationnelle	Capacité d'une structure à rendre information et services faciles à trouver, comprendre et utiliser
Médiation en santé	Fonction d'interface entre publics éloignés et professionnels (art. L. 1110-13 CSP ; HAS, 2017)
Précautions universelles	Communication claire appliquée à tous, sans repérage stigmatisant
Pictogramme	Dessin simple qui représente une action, un objet ou une information
Allophone	Personne dont la langue maternelle n'est pas celle du pays où elle vit

Terme	Définition
Fréquences naturelles	Présentation d'un risque en nombre de personnes (« 6 sur 100 »)
Numératie	Capacité à comprendre et utiliser nombres, pourcentages et risques
RGAA	Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité des services numériques publics
Règlement INCO	Règlement (UE) n° 1169/2011 sur l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires
Réduction absolue / relative	Différence de risques en points / rapportée au risque initial
Tableau d'icônes	Représentation d'un risque par 100 (ou 1 000) pictogrammes dont certains colorés
Texte alternatif	Description textuelle d'une image, lue par les logiciels de synthèse vocale

5.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Définitions, modèles	[1] Sørensen ; [2] Nutbeam 2000 ; [3] Nutbeam 2008 ; [4] Vidgen et Gallegos
Données	[5] HLS19 ; [6] ANLCI ; [7] Insee illectronisme ; [8] OCDE PIAAC
Conséquences	[9] Berkman et coll.
Adapter, FALC	[10] Santé publique France, Communiquer pour tous ; [11] Inclusion Europe ; [12] Kandel et Moles
Faire dire, médiation	[13] HAS Faire dire ; [14] HAS médiation et interprétariat
Organisations, mesure	[15] Brach et coll. ; [16] Norman et Skinner ; [17] Weiss (NVS)

5.12 Bibliographie numérotée

1. Sørensen K., Van den Broucke S., Fullam J. et coll. « Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models ». *BMC Public Health*, 2012, 12, 80.

2. Nutbeam D. « Health literacy as a public health goal ». *Health Promotion International*, 2000, 15 (3), p. 259-267.

3. Nutbeam D. « The evolving concept of health literacy ». *Social Science & Medicine*, 2008, 67 (12), p. 2072-2078.

4. Vidgen H. A., Gallegos D. « Defining food literacy and its components ». *Appetite*, 2014, 76, p. 50-59.

5. The HLS19 Consortium of the WHO Action Network M-POHL. *International Report on the Methodology, Results, and Recommendations of the European Health Literacy Population Survey 2019-2021 (HLS19)*. 2021 (rapport international et résultats France).

6. Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI). *L'évolution de l'illettrisme en France* (enquête IVQ 2011, Insee). 2013.

7. Insee. Enquête TIC ménages 2025 (usages et compétences numériques), publiée le 19 février 2026 ; pour l'évolution : *Insee Première* sur l'illectronisme en 2021, 2023.

8. OCDE. *Survey of Adult Skills 2023 (PIAAC, 2e cycle)*. Décembre 2024 ; Dares. « Compétences des adultes en 2023 ». *Dares Analyses* n° 73, décembre 2024.

9. Berkman N. D. et coll. « Low health literacy and health outcomes: an updated systematic review ». *Annals of Internal Medicine*, 2011, 155 (2), p. 97-107.

10. Ruel J., Allaire C. (dir.). *Communiquer pour tous : guide pour une information accessible*. Santé publique France, mai 2018, mise à jour février 2025.

11. Inclusion Europe. *L'information pour tous : règles européennes pour une information facile à lire et à comprendre*. 2009.

12. Kandel L., Moles A. « Application de l'indice de Flesch à la langue française ». *Cahiers d'études de radio-télévision*, 1958, 19, p. 253-274.

13. HAS. *Faire dire*. Fiche outil, 2015.

14. HAS. *La médiation en santé pour les personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins* ; *Interprétariat linguistique dans le domaine de la santé*. Référentiels de compétences, 2017.

15. Brach C. et coll. *Ten Attributes of Health Literate Health Care Organizations*. Institute of Medicine, 2012.

16. Norman C. D., Skinner H. A. « eHealth literacy: essential skills for consumer health in a networked world ». *Journal of Medical Internet Research*, 2006, 8 (2), e9.

17. Weiss B. D. et coll. « Quick assessment of literacy in primary care: the Newest Vital Sign ». *Annals of Family Medicine*, 2005, 3 (6), p. 514-522.

18. Marmot M. *Fair Society, Healthy Lives* (The Marmot Review). 2010.

19. Règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (INCO).

20. Santé publique France. *Nutri-Score* : documents de référence et mise à jour de l'algorithme (2022-2024), *santepubliquefrance.fr*.

21. OMS. *Guideline: Sugars intake for adults and children*. Genève, 2015.

22. Gigerenzer G. *Calculated Risks: How to Know When Numbers Deceive You*. New York, Simon & Schuster, 2002.

23. DINUM. *Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA)*, version 4, *accessibilite.numerique.gouv.fr*.

24. W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. 2023.

25. Conférence nationale de santé. *La littératie en santé – usagers et professionnels : tous concernés*. Avis adopté le 6 juillet 2017.

26. Van den Broucke S. « La littératie en santé : un concept critique pour la santé publique ». *La Santé en action*, n° 440, juin 2017.

27. Le Brun M., Godard D., Camps L. et coll. « La littératie en santé : définition, outils d'évaluation, état des lieux en Europe ». *La Revue de médecine interne*, 2025, 46, p. 32-39.

28. DEPP. « Journée défense et citoyenneté 2025 : 14 % des jeunes rencontrent des difficultés de lecture ». *Note d'information* n° 26.43, octobre 2026.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 5.2.2)

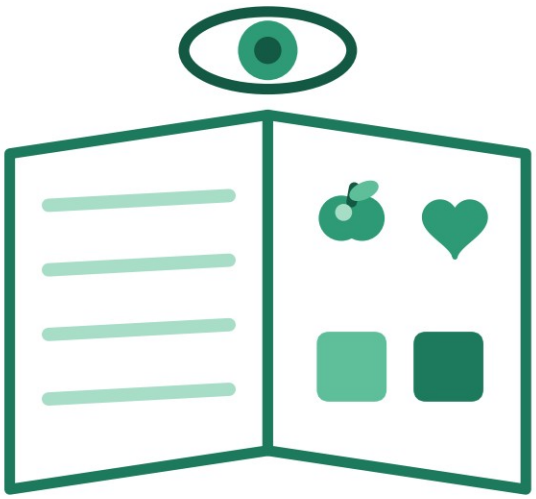
29. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

30. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE



05

CHAPITRE

05

Littératie en santé

Littératie en santé | Repérer | Adapter | Vérifier la compréhension

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

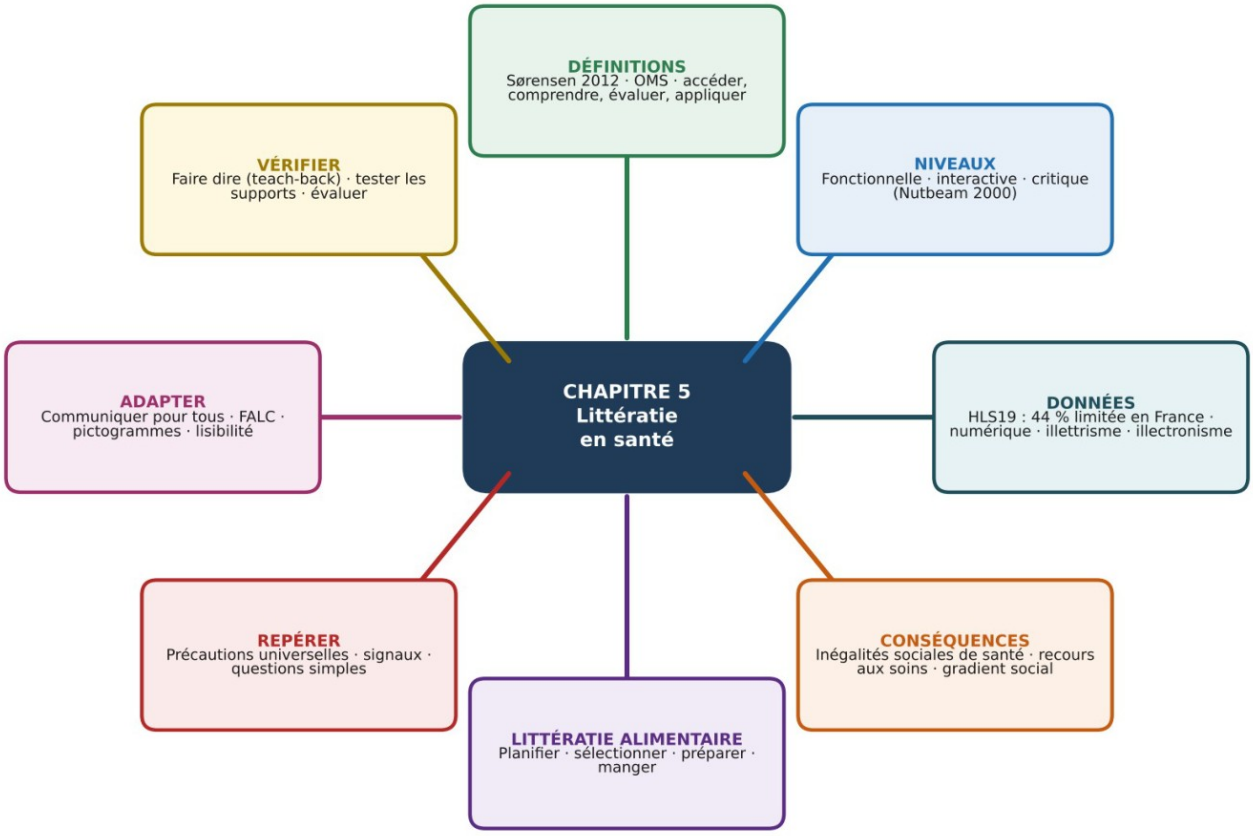
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 5 100
1. Les définitions à savoir 100
2. Chiffres-clés 101
3. La formule à connaître 101
4. Les règles d'écriture claire 101
5. Faire dire 101
6. Les pièges 101
7. Auto-test 101
8. Flashcards 101
Compléments du chapitre enrichi 102

Fiches-outils du chapitre 5 102
O5.1 – Grille de vérification d'un support écrit 102
O5.2 – Calcul de l'indice de lisibilité 103
O5.3 – Audit « littératie » d'une structure 103
O5.4 – Guide du faire dire 103
O5.5 – Test d'un support auprès du public 104

Fiche de révision du chapitre 5

Littératie en santé



Carte mentale du chapitre 5

1. Les définitions à savoir

Notion	Définition
Littératie en santé	Connaissances, motivation, compétences pour accéder, comprendre, évaluer, appliquer l'information ; soins, prévention, promotion (Sørensen, 2012)
Niveaux (Nutbeam, 2000)	Fonctionnel (lire) · interactif (échanger) · critique (juger, agir)
Littératie alimentaire	Planifier et gérer · sélectionner · préparer · manger (Vidgen et Gallegos, 2014)
Littératie organisationnelle	Une structure rend l'information facile à trouver, comprendre, utiliser
Illettrisme / analphabétisme	Scolarisé en France sans maîtrise suffisante / jamais scolarisé
Illectronisme	Difficulté ou incapacité à utiliser le numérique
Précautions universelles	Communiquer clairement avec tous, sans tester
FALC	Facile à lire et à comprendre (Inclusion Europe, 2009), relu par des personnes concernées

2. Chiffres-clés

- **44 %** des adultes en France : littératie en santé limitée (HLS19, 2021), ≈ 30 % problématique + 14 % insuffisante ; difficultés plus fréquentes en numérique (≈ 72 %).
- Illettrisme : **7 %** des 18-65 ans, 2,5 millions (ANLCI, 2011).
- Illectronisme : **7 %** des 16-74 ans en 2025 (Insee, 2026) ; 34 % en difficulté numérique.

3. La formule à connaître

Méthode pas à pas – Lisibilité (Kandel et Moles, 1958)

L = 207 − 1,015 × (mots / phrases) − 73,6 × (syllabes / mots) ; 60-70 standard ; 80-90 facile. Exemple : 120 mots, 5 phrases, 204 syllabes → 207 − 24,36 − 125,12 = **57,52**.

4. Les règles d'écriture claire

Une idée par phrase (≤ 15 mots) · mots courants · forme active et positive · pas de sigles · chiffres concrets · pictogrammes et photos réelles · police ≥ 14, aligné à gauche · tester auprès du public.

5. Faire dire

Expliquer → faire reformuler → vérifier → réexpliquer autrement → confirmer (HAS, 2015). Jamais « Vous avez compris ? ».

6. Les pièges

Attention

- Confondre littératie et intelligence ou niveau d'études.
- Additionner illettrisme, illectronisme et littératie limitée.
- « Tester » le public au lieu d'appliquer les précautions universelles.
- Tout miser sur le numérique.
- Faire traduire un enfant ou un traducteur automatique non relu.

7. Auto-test

1. Les 4 compétences de Sørensen ? 2. Les 3 domaines ? 3. Les 3 niveaux de Nutbeam ? 4. Chiffre HLS19 ? 5. Différence illettrisme / analphabétisme ? 6. Que signifie FALC ? 7. Que mesure l'indice de Kandel et Moles ? 8. Les étapes du faire dire ? 9. Les 4 domaines de la littératie alimentaire ? 10. Article du CSP sur la médiation en santé ? *Réponses : 1. Accéder, comprendre, évaluer, appliquer – 2. Soins, prévention, promotion – 3. Fonctionnel, interactif, critique – 4. 44 % limitée – 5. Scolarisé en France ou jamais scolarisé – 6. Facile à lire et à comprendre – 7. La lisibilité (longueur des phrases et des mots) – 8. Expliquer, faire dire, vérifier, réexpliquer, confirmer – 9. Planifier, sélectionner, préparer, manger – 10. L. 1110-13.*

8. Flashcards

Recto : Littératie critique ?	Verso : Juger la fiabilité et agir sur les déterminants, seul ou collectivement
Recto : Pourquoi la littératie creuse-t-elle les ISS ?	Verso : Les messages non adaptés profitent d'abord aux plus favorisés

Recto : Littératie critique ?	Verso : Juger la fiabilité et agir sur les déterminants, seul ou collectivement
Recto : Universalisme proportionné ?	Verso : Action pour tous, intensité adaptée aux besoins (Marmot, 2010)
Recto : 6 questions de fiabilité ?	Verso : Qui ? Objectif ? Sources ? Date ? Cohérence ? Promesse miraculeuse ?
Recto : Outil de mesure par l'étiquette ?	Verso : Newest Vital Sign (Weiss, 2005)
Recto : Évaluer avec des enfants ?	Verso : Smileys, gommettes, question orale

Compléments du chapitre enrichi

Notion	À retenir
Étiquette	INCO 1169/2011 ; dénomination, ingrédients (ordre décroissant, 14 allergènes), Nutri- Score (même famille), tableau pour 100 g et par portion, dates, prix au kilo
Sucres	g/100 mL × volume / 100 ; 1 morceau ≈ 5 g ; OMS : < 10 % de l'énergie (≈ 50 g pour 2 000 kcal)
Numératie	Fréquences naturelles, tableaux d'icônes ; donner réductions absolue ET relative
Numérique	Grille d'évaluation des applications ; RGAA/WCAG ; texte alternatif, sous-titres
Allophones	Interprétariat professionnel, médiateurs, pictogrammes testés ; pas d'enfant interprète
Tester	Lisibilité + test de compréhension auprès du public

Fiches-outils du chapitre 5

Outil	Intitulé	Utilité
O5.1	Grille de vérification d'un support écrit	Avant impression d'une affiche, d'un dépliant, d'une fiche recette
O5.2	Calcul de l'indice de lisibilité	Mesurer et comparer deux versions d'un texte
O5.3	Audit « littératie » d'une structure	Proposer des améliorations à un partenaire
O5.4	Guide du faire dire	Vérifier la compréhension en entretien et en atelier
O5.5	Test d'un support auprès du public	Recueillir l'avis de 5 à 8 personnes

O5.1 – Grille de vérification d'un support écrit

Critère	Oui	Non	À revoir
Le titre dit ce que la personne va faire ou gagner	☐	☐	☐
Un message principal, 3 idées au plus	☐	☐	☐
Phrases de 15 mots au plus, une idée par phrase	☐	☐	☐
Mots courants, aucun sigle non expliqué	☐	☐	☐
Forme active et positive (« Buvez de l'eau »)	☐	☐	☐
Chiffres concrets (verre, poignée, cuillère)	☐	☐	☐
Images utiles et réalistes, qui disent la même chose que le texte	☐	☐	☐
Police sans empattement ≥ 14, aligné à gauche, pas de majuscules continues	☐	☐	☐
Contraste suffisant, mise en page aérée	☐	☐	☐

Critère	Oui	Non	À revoir
Informations pratiques claires (quand, où, coût, contact)	☐	☐	☐
Accès non exclusivement numérique	☐	☐	☐
Source et date indiquées	☐	☐	☐
Testé auprès de personnes du public	☐	☐	☐

O5.2 – Calcul de l'indice de lisibilité

Étape	Version 1	Version 2
Nombre de mots (M)		
Nombre de phrases (P)		
Nombre de syllabes (S)		
M / P		
S / M		
1,015 × (M / P)		
73,6 × (S / M)		
L = 207 − 1,015 × (M/P) − 73,6 × (S/M)		
Interprétation		

0-30 très difficile · 30-50 difficile · 50-60 assez difficile · 60-70 standard · 70-80 assez facile · 80-90 facile · 90-100 très facile.

O5.3 – Audit « littératie » d'une structure

Point observé	Constat (satisfaisant ou à améliorer)	Proposition
Le lieu est facile à trouver (signalétique, plan, pictogrammes)		
L'accueil propose de l'aide pour les papiers		
Les documents sont clairs (grille O5.1)		
Plusieurs langues ou un accès à l'interprétariat		
Inscriptions possibles sans numérique		
Les professionnels vérifient la compréhension (faire dire)		
Les usagers participent à la conception des supports		
Les coûts sont annoncés clairement		

O5.4 – Guide du faire dire

Étape	Formulations possibles
Annoncer	« Je vais vous expliquer… ensuite je vous demanderai de me le redire, pour vérifier que j'ai été clair(e). »
Expliquer	Un message à la fois ; un objet, une image, un geste
Faire dire	« Comment allez-vous l'expliquer à votre famille ? » ; « Montrez-moi comment vous feriez. »

Étape	Formulations possibles
Si incomplet	« Je me suis peut-être mal exprimé(e), je reprends autrement… »
Confirmer	« C'est exactement ça. » ; laisser un support d'une page
En groupe	« Chaque binôme explique au groupe une astuce retenue. »

O5.5 – Test d'un support auprès du public

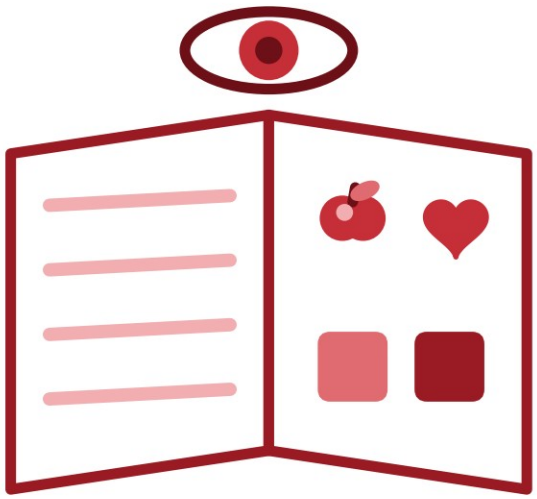
Question posée	Personne 1	Personne 2	Personne 3
« Que vous dit ce document ? »			
« Qu'allez-vous faire après l'avoir lu ? »			
Mots ou images non compris			
Ce qui plaît / ne plaît pas			
Proposition de la personne			

Conclusion : modifications à apporter avant impression.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES



05

CHAPITRE

05

Littératie en santé

Littératie en santé | Repérer | Adapter | Vérifier la compréhension

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 5 108
Mode d'emploi du cahier 108
Partie 1 – Définir la littératie en santé et la littératie alimentaire 110
Exercice 5.1 – Légender les 12 dimensions de la littératie en santé (10 points) 111
Exercice 5.2 – Les trois niveaux de Nutbeam (10 points) 113
Exercice 5.3 – La littératie alimentaire d'étudiants (10 points) 115
Exercice 5.4 – Le parcours d'inscription à la cantine : une question d'organisation (12 points) 117
Exercice 5.5 – Personne, situation, complexité de l'information (10 points) 119
Exercice 5.6 – Diagnostiquer avec la grille de Sørensen (16 points) 121
Corrigés de la partie 1 123
Partie 2 – Les données françaises et les enjeux pour la santé publique 126
Exercice 5.7 – Légender les mesures françaises et distinguer les notions (10 points) 127
Exercice 5.8 – Transposer l'enquête HLS19 à une commune (10 points) 129
Exercice 5.9 – Le gradient social de la littératie (12 points) 131
Exercice 5.10 – Comprendre son plan alimentaire quand on a un diabète (12 points) 133
Exercice 5.11 – Une campagne qui creuse les écarts (12 points) 134
Exercice 5.12 – Le Nutri-Score, un outil pensé pour la littératie (14 points) 135
Corrigés de la partie 2 137
Partie 3 – Repérer sans stigmatiser et adapter le diagnostic 140
Exercice 5.13 – Vrai ou faux : les précautions universelles (8 points) 141
Exercice 5.14 – Les signaux à l'accueil d'une épicerie solidaire (10 points) 142
Exercice 5.15 – Réécrire un questionnaire de diagnostic (12 points) 143
Exercice 5.16 – Questionnaire écrit ou passation orale ? (12 points) 145
Exercice 5.17 – Poser les bonnes questions sans juger (10 points) 147
Exercice 5.18 – Diagnostic dans une résidence sociale (16 points) 148
Corrigés de la partie 3 150
Partie 4 – Écrire clair, FALC et mesure de la lisibilité 153
Exercice 5.19 – Les six étapes d'une communication accessible (10 points) 154
Exercice 5.20 – Calculer et situer trois indices de lisibilité (10 points) 156
Exercice 5.21 – Appliquer les règles d'écriture claire (12 points) 158
Exercice 5.22 – La lettre aux familles sur le goûter (14 points) 160
Exercice 5.23 – Un menu en FALC pour un ESAT (12 points) 162
Exercice 5.24 – Les limites de l'indice de lisibilité (12 points) 164
Corrigés de la partie 4 166
Partie 5 – Vérifier la compréhension et animer un atelier accessible 168
Exercice 5.25 – Légender la boucle du « faire dire » (10 points) 169
Exercice 5.26 – Des questions qui font agir (8 points) 171
Exercice 5.27 – Analyser un « faire dire » en entretien (12 points) 172
Exercice 5.28 – Construire une séquence d'atelier accessible (14 points) 174
Exercice 5.29 – Exploiter une grille de « faire dire » (12 points) 176
Exercice 5.30 – Un message vocal pour rappeler l'atelier (10 points) 178
Corrigés de la partie 5 179
Partie 6 – Lire une étiquette et comprendre les chiffres : littératie alimentaire et numératie 181
Exercice 5.31 – Légender une étiquette (10 points) 182
Exercice 5.32 – Lire trois listes d'ingrédients (10 points) 184
Exercice 5.33 – Les boissons en morceaux de sucre (12 points) 186
Exercice 5.34 – Pour 100 g ou par portion ? Deux goûters comparés (12 points) 188
Exercice 5.35 – Présenter honnêtement un risque (12 points) 190

Exercice 5.36 – Traduire les repères chiffrés en assiettes (14 points) 192
Corrigés de la partie 6 194

Partie 7 – Numérique, langues et handicaps : rendre l'information accessible 196
Exercice 5.37 – Une adaptation pour chaque situation (10 points) 197
Exercice 5.38 – Évaluer une application de scan (10 points) 199
Exercice 5.39 – Rendre accessible la page d'inscription (14 points) 201
Exercice 5.40 – Communiquer avec des parents allophones (10 points) 203
Exercice 5.41 – Un atelier cuisine avec des personnes sourdes et malentendantes (12 points) 205
Exercice 5.42 – Le club des seniors et le numérique (14 points) 207
Corrigés de la partie 7 209

Partie 8 – Outils pédagogiques, littératie dans le projet et cas complet 212
Exercice 5.43 – La littératie à chaque étape du projet (10 points) 213
Exercice 5.44 – Analyser un kit pédagogique offert par une marque (10 points) 214
Exercice 5.45 – Créer des cartes-prix pour un jeu de numératie (12 points) 216
Exercice 5.46 – Évaluer avec des smileys (12 points) 218
Exercice 5.47 – Un budget de communication accessible (12 points) 219
Exercice 5.48 – Cas complet : cuisiner le colis au centre d'hébergement (40 points) 221
Corrigés de la partie 8 224

Bilan : grille d'auto-évaluation 227

Cahier d'exercices – Chapitre 5

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 5 : définitions et modèles de la littératie en santé (Sørensen, Nutbeam), littératie alimentaire, littératie organisationnelle, données françaises (HLS19, illettrisme, illectronisme), conséquences et inégalités sociales de santé, repérage sans stigmatisation, écriture claire et FALC, lisibilité, « faire dire », lecture d'étiquette, numératie, inclusion numérique, publics allophones et en situation de handicap, outils pédagogiques et intégration à chaque étape du projet (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition », C3.2 « Concevoir et réaliser des ateliers culinaires adaptés au public visé » et C3.5 « Communiquer et interagir dans un contexte d'intervention en santé » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les 12 dimensions de Sørensen, les trois niveaux de Nutbeam, les domaines de la littératie alimentaire, les mesures françaises, les six étapes d'une communication accessible, l'échelle de lisibilité, la boucle du « faire dire », l'étiquette, les fréquences naturelles, les adaptations selon les publics, la littératie dans le projet.
- Calculer et interpréter : pourcentages d'un diagnostic, indice de lisibilité de Kandel et Moles, taux de compréhension avant et après, risque relatif, réductions absolue et relative, sucres en morceaux, valeurs « pour 100 g » et « par portion », ratio de contraste, coût par portion (Ciqual 2025).
- Proposer des messages, des supports et des séances que tout le public peut comprendre, sans désigner personne.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits d'entretiens), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, prix et chiffres des enquêtes locales sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025) ; pour les boissons, on assimile 100 g à 100 mL. Les auteurs, les textes officiels, les enquêtes nationales et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés.

Méthode – Traiter une question de littératie à l'examen

Pour chaque situation, suivez trois temps. D'abord, repérez où se situe la difficulté : trouver, comprendre, juger ou utiliser l'information, et dans quel domaine (soins, prévention, promotion de la santé). Ensuite, citez un élément précis du document qui le montre. Enfin, proposez une adaptation qui vaut pour tout le public (précautions universelles) et dites comment vous vérifierez qu'elle marche : test du support auprès de

personnes du public, « faire dire » en séance, indicateur de compréhension. Une copie qui « teste » ou désigne les personnes en difficulté perd des points.

Partie 1 – Définir la littératie en santé et la littératie alimentaire

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir la littératie en santé selon Sørensen (2012) et citer ses quatre compétences et ses trois domaines.
- Situer une situation dans les trois niveaux de Nutbeam (2000).
- Définir la littératie alimentaire et ses quatre domaines (Vidgen et Gallegos, 2014).
- Distinguer la littératie d'une personne et la littératie d'une organisation.
- Utiliser la grille des 12 dimensions pour analyser les besoins d'un public.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Littératie en santé (Sørensen et coll., 2012) : connaissances, motivation et compétences pour accéder, comprendre, évaluer et appliquer l'information en santé, dans les soins, la prévention et la promotion de la santé.
- Quatre compétences × trois domaines = 12 dimensions ; l'enquête européenne HLS-EU les mesure par 47 questions.
- Trois niveaux (Nutbeam, 2000) : fonctionnel (lire, écrire, compter), interactif (échanger, adapter l'information à sa situation), critique (juger, analyser, agir sur les déterminants avec d'autres).
- Littératie alimentaire (Vidgen et Gallegos, 2014) : planifier et gérer, sélectionner, préparer, manger ; 4 domaines et 11 composantes.
- Littératie organisationnelle : capacité d'une structure à rendre l'information et les services faciles à trouver, à comprendre et à utiliser.
- La littératie n'est ni l'intelligence ni le niveau d'études : elle dépend de la personne, de la situation et de la complexité de l'information.

Exercice 5.1 – Légender les 12 dimensions de la littératie en santé (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous présentez la littératie en santé à l'équipe d'une maison de santé pluriprofessionnelle qui veut mieux accompagner ses patients. Vous projetez le schéma de Sørensen et vous demandez aux professionnels de le compléter avec des exemples alimentaires.

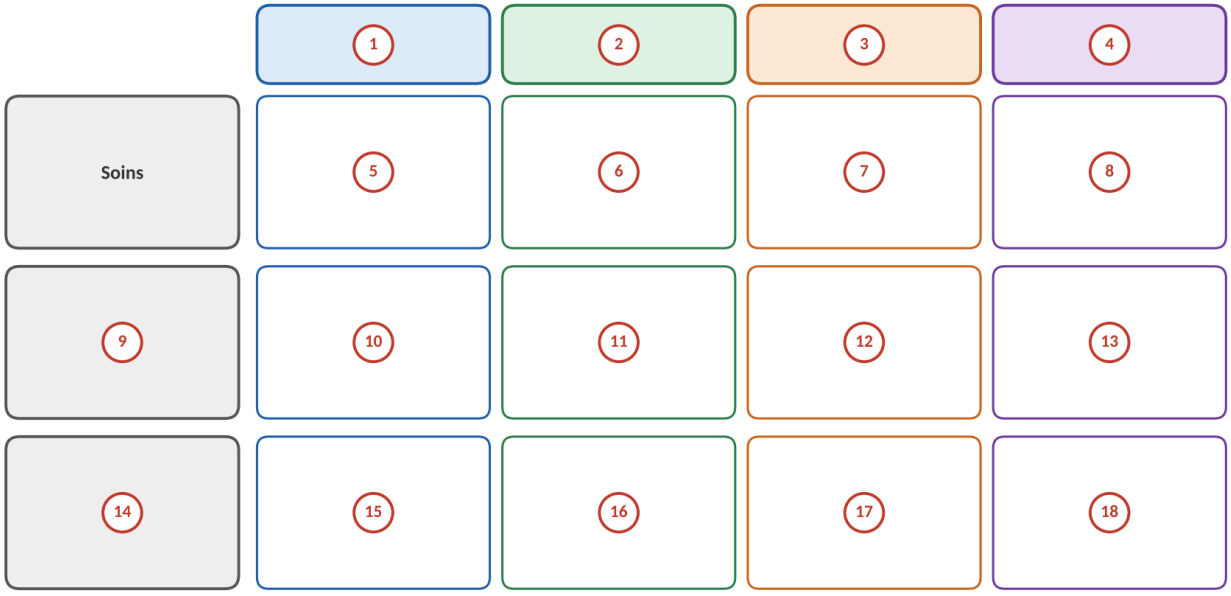


Figure 5.1 – Document 1 – Les 12 dimensions de la littératie en santé (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 18 du document 1 : les quatre compétences, les deux domaines manquants et un exemple alimentaire pour chaque case. (6 pts)
2. Donnez la définition de la littératie en santé de Sørensen et coll. (2012) en citant les quatre compétences et les trois domaines. (2 pts)
3. Expliquez en deux phrases pourquoi ce schéma sert de grille de diagnostic pour un projet. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.2 – Les trois niveaux de Nutbeam (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une intervention sur l'alimentation pour un groupe de salariés en reconversion. Vous voulez leur montrer qu'il existe plusieurs niveaux de littératie et que chacun peut progresser.

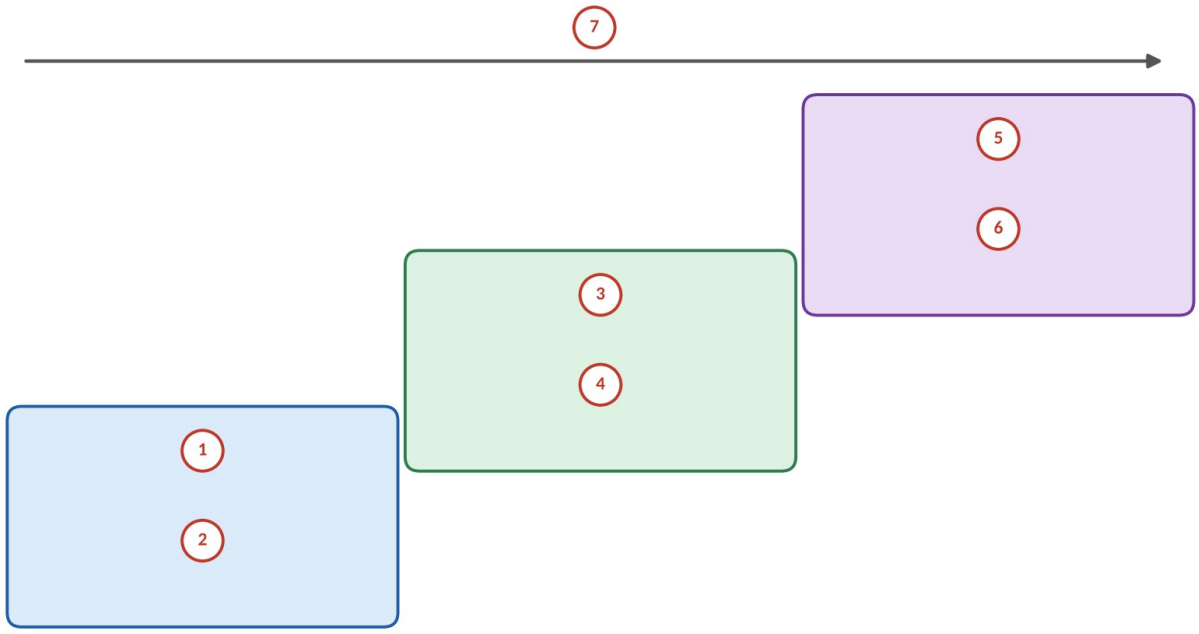


Figure 5.2 – Document 1 – Les trois niveaux de littératie en santé (schéma à légender)

Document 2 – Huit situations observées pendant l'intervention

a) Karim lit sur le sachet de lentilles le temps de cuisson indiqué.

b) Sophie demande à l'intervenante si le conseil « 5 fruits et légumes » vaut aussi pour son fils de 3 ans.

c) Thierry remarque que la publicité pour une boisson « riche en vitamines » ne parle pas du sucre.

d) Leïla calcule le prix au kilo de deux paquets de riz.

e) Un collectif d'habitants obtient du bailleur social des parcelles de jardin partagé au pied des immeubles.

f) Marc, chauffeur routier, explique ses horaires à la diététicienne et lui demande comment organiser ses repas sur la route.

g) Nadia vérifie qui a publié une vidéo « détox » avant de la partager.

h) Paul suit la notice pour préparer un biberon de lait infantile.

À vous de jouer – Questions

1. **1.** Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)
2. **2.** Classez chaque situation du document 2 dans un des trois niveaux. (4 pts)
3. **3.** Expliquez pourquoi la situation e) relève de la promotion de la santé et du pouvoir d'agir. (1,5 pt)
4. **4.** Citez une action d'atelier qui fait passer le groupe du niveau fonctionnel au niveau interactif. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.3 – La littératie alimentaire d'étudiants (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une épicerie sociale étudiante (fictive) vous demande d'animer quatre séances pour des étudiants de première année qui vivent seuls pour la première fois. La responsable vous transmet ce qu'elle entend à la caisse.

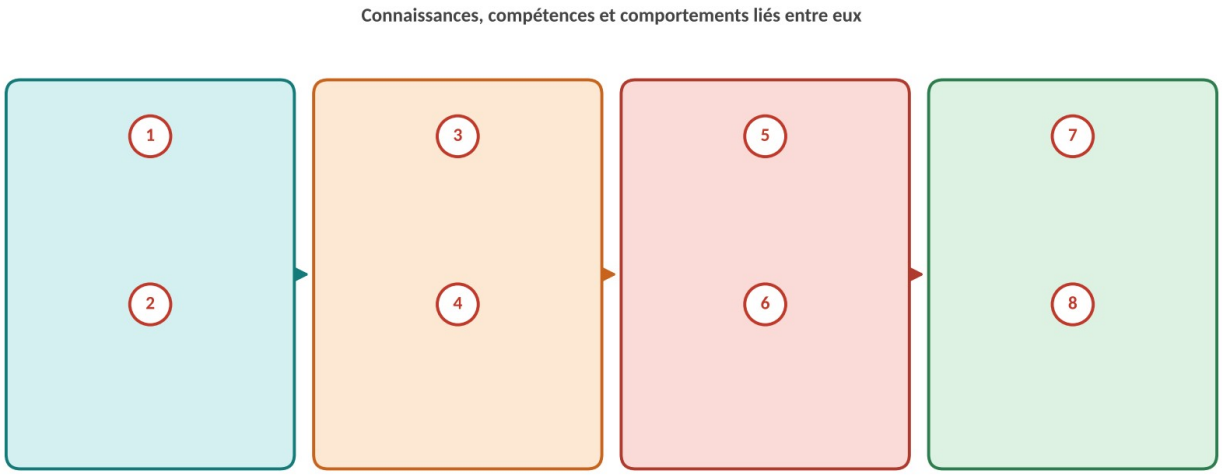


Figure 5.3 – Document 1 – Les quatre domaines de la littératie alimentaire (schéma à légender)

Document 2 – Ce que disent les étudiants

a) « Je fais les courses quand le frigo est vide, sans liste, et j'achète trop de choses que je jette. »

b) « Je ne sais pas cuire des lentilles, alors j'achète des plats préparés. »

c) « Je ne comprends pas pourquoi deux paquets de céréales qui se ressemblent n'ont pas le même Nutri-Score. »

d) « Je mange devant mon ordinateur, souvent à 22 h, et je ne sens plus si j'ai faim. »

e) « À la fin du mois, il me reste 15 € pour dix jours. »

f) « Je ne sais pas combien de temps on peut garder un reste de riz au frigo. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Rattachez chaque phrase du document 2 à un domaine de la littératie alimentaire. (3 pts)
3. Proposez un titre et un objectif pour chacune des quatre séances, un par domaine. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.4 – Le parcours d'inscription à la cantine : une question d'organisation (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de restauration scolaire d'une commune de 18 000 habitants (fictive) constate que beaucoup de familles des quartiers prioritaires ne demandent pas le tarif social de la cantine. Il vous demande d'analyser le parcours d'inscription.

Document 1 – Le parcours actuel, décrit par une médiatrice sociale

- L'inscription se fait uniquement sur le « portail famille » en ligne, avec un identifiant reçu par courriel.
- Le formulaire compte 9 pages ; il utilise les mots « quotient familial », « justificatif de domicile de moins de 3 mois » et « PAI ».
- Le tarif social demande de télécharger l'avis d'imposition au format PDF.
- Le règlement intérieur de 14 pages est en police de 9 points, sans image.
- L'accueil de la mairie est ouvert de 9 h à 12 h, du lundi au vendredi.
- Le menu est affiché à l'entrée de l'école en texte seul, sans pictogrammes pour les allergènes.
- Aucune information n'existe dans une autre langue que le français.
- Une famille témoigne : « On m'a dit de tout faire sur internet. Je n'ai qu'un téléphone et ma fille m'aide le soir. »

À vous de jouer – Questions

1. Définissez la littératie en santé organisationnelle et dites en quoi elle déplace la responsabilité. (2 pts)
2. Relevez dans le document 1 six obstacles qui viennent de l'organisation et non des familles. (3 pts)
3. Pour chaque obstacle relevé, proposez une amélioration réaliste pour la commune. (4 pts)
4. Expliquez pourquoi ce parcours peut creuser les inégalités sociales de santé, alors que le tarif social veut les réduire. (2 pts)
5. Proposez un indicateur pour savoir si les améliorations fonctionnent. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.5 – Personne, situation, complexité de l'information (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une réunion d'équipe dans un centre communal d'action sociale (CCAS), un collègue affirme : « La littératie, c'est un problème de personnes qui ne savent pas lire. Chez nous, les gens diplômés n'en ont pas besoin. » Vous lui présentez des situations recueillies pendant votre stage.

Document 1 – Cinq situations

a) Hélène, ingénieure, vient d'apprendre que son mari a un cancer. Pendant l'entretien, elle ne retient rien des conseils pour la dénutrition.

b) Moussa, maçon, lit difficilement mais explique très bien à l'animatrice comment il adapte le ramadan à son diabète, avec les conseils de son médecin.

c) Claire, professeure de lettres, ne comprend pas le tableau nutritionnel « pour 100 g » et « par portion » d'un plat préparé.

d) Ana, arrivée du Brésil il y a six mois, est infirmière diplômée ; elle parle peu le français.

e) Jean, 82 ans, ancien comptable, a du mal à lire les petits caractères des étiquettes et n'utilise pas internet.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque situation, dites si la difficulté vient surtout de la personne, de la situation ou de la complexité de l'information. Justifiez en une phrase. (5 pts)
2. Expliquez pourquoi on parle de « situations de littératie limitée » plutôt que de « personnes illettrées en santé ». (2 pts)
3. Rédigez la réponse que vous faites à votre collègue en trois phrases, sans le mettre en défaut. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.6 – Diagnostiquer avec la grille de Sørensen (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de santé au travail d'un entrepôt de logistique (fictif) prépare une action « bien manger quand on travaille en horaires décalés ». Avec l'infirmière, vous avez fait passer en entretien un questionnaire court inspiré de l'enquête HLS-EU à 60 salariés volontaires. Chaque question demande s'il est facile ou difficile de réaliser une tâche.

Document 1 – Nombre de salariés qui répondent « difficile » ou « très difficile » (n = 60, données fictives)

Domaine	Accéder	Comprendre	Évaluer	Appliquer
Soins (« … un régime prescrit par le médecin »)	14	18	33	12
Prévention (« … les repères pour bien manger »)	11	21	38	16
Promotion de la santé (« … l'offre de repas de l'entreprise »)	19	17	35	24

Document 2 – Extraits des entretiens

- « Sur internet, chacun dit le contraire. Le jeûne, le sans gluten… je ne sais plus qui croire. »
- « Le distributeur ne propose que des sandwichs et des barres. On n'a pas notre mot à dire. »
- « La nuit, je ne sais pas si je dois manger à 2 h ou attendre le matin. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque case du document 1, le pourcentage de salariés en difficulté (au dixième). (4 pts)
2. Calculez le pourcentage moyen de difficulté pour chaque compétence (sur les trois domaines) et pour chaque domaine (sur les quatre compétences). (3 pts)
3. Identifiez la compétence et la case les plus en difficulté, et reliez-les à un extrait du document 2. (2 pts)
4. Formulez deux objectifs spécifiques de l'action, l'un sur la compétence la plus faible, l'autre sur la promotion de la santé. (3 pts)
5. Proposez deux activités, l'une pour développer l'esprit critique, l'autre pour donner du pouvoir d'agir sur l'offre de l'entreprise. (2 pts)
6. Citez deux limites de ces données. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 5.1

1. Légendes : 1 Accéder ; 2 Comprendre ; 3 Évaluer ; 4 Appliquer ; 5 trouver le numéro de la diététicienne ; 6 comprendre un régime prescrit ; 7 juger un second avis ; 8 suivre le plan alimentaire ; 9 Prévention ; 10 trouver les repères du PNNS ; 11 comprendre le Nutri-Score ; 12 juger un conseil vu sur un réseau social ; 13 choisir un produit au magasin ; 14 Promotion de la santé ; 15 connaître l'offre du quartier ; 16 comprendre un menu affiché ; 17 juger la qualité de la cantine ; 18 agir en association de parents. Tout autre exemple alimentaire juste est accepté.
2. Selon Sørensen et coll. (2012), la littératie en santé englobe les connaissances, la motivation et les compétences qui permettent d'accéder, de comprendre, d'évaluer et d'appliquer l'information en santé. Elle sert à prendre des décisions dans la vie quotidienne dans trois domaines : les soins, la prévention des maladies et la promotion de la santé.
3. La grille permet de situer précisément la difficulté d'un public : ce n'est pas la même chose de ne pas trouver une information et de ne pas savoir la juger. On en déduit des objectifs pédagogiques précis et des activités adaptées à chaque case.

Corrigé – Exercice 5.2

1. Légendes : 1 Fonctionnelle ; 2 lire, écrire, compter pour comprendre une information simple (étiquette, date, dépliant) ; 3 Interactive ; 4 échanger, poser des questions, adapter l'information à sa situation ; 5 Critique ; 6 juger la fiabilité, analyser la publicité, agir sur les déterminants avec d'autres ; 7 plus d'autonomie et de pouvoir d'agir.
2. Fonctionnelle : a) lire une information simple sur un emballage, d) calculer un prix au kilo, h) suivre une notice. Interactive : b) poser une question pour adapter le conseil à son enfant, f) expliquer sa situation à la diététicienne pour obtenir un conseil adapté. Critique : c) analyser une publicité, e) agir collectivement sur l'offre alimentaire du quartier, g) vérifier la source d'une vidéo.
3. Les habitants ne changent pas seulement leur propre comportement : ils agissent ensemble sur un déterminant de la santé de tout le quartier (l'accès à des fruits et légumes cultivés sur place, une activité physique et du lien social). C'est le niveau critique de Nutbeam et l'axe « créer des milieux favorables » de la Charte d'Ottawa (1986).
4. Exemple : après la lecture d'une étiquette, chaque participant pose une question sur sa propre situation (« et pour mon enfant ? ») et l'animatrice l'aide à adapter le conseil ; ou un jeu de rôle « je pose ma question au diététicien ».

Corrigé – Exercice 5.3

1. Légendes : 1 Planifier et gérer ; 2 prévoir les repas, faire une liste, gérer un budget et des réserves ; 3 Sélectionner ; 4 savoir où acheter, lire une étiquette, juger la fraîcheur ; 5 Préparer ; 6 cuisiner avec ce que l'on a, hygiène, techniques de base ; 7 Manger ; 8 écouter ses sensations, partager, connaître les repères.
2. a) planifier et gérer (liste, gaspillage) ; b) préparer (technique de base) ; c) sélectionner (lire une étiquette) ; d) manger (sensations, conditions du repas) ; e) planifier et gérer (budget) ; f) préparer (hygiène, conservation des restes).
3. Exemples : « Ma semaine en 10 minutes » : savoir établir un menu de 5 jours et une liste de courses ; « Le rayon mode d'emploi » : savoir comparer deux produits d'une même famille avec le Nutri-Score et le prix au kilo ; « Cuisiner 3 recettes avec un paquet de lentilles » : savoir cuire des lentilles et conserver un reste en sécurité ; « Mon repas, ma pause » : savoir repérer sa faim et organiser un repas sans écran. Un objectif commence par un verbe d'action et se vérifie à la fin de la séance.

Corrigé – Exercice 5.4

1. C'est la capacité d'une organisation à rendre l'information et les services faciles à trouver, à comprendre et à utiliser pour tous. La responsabilité ne repose plus seulement sur la personne (« elle devrait savoir faire ») : c'est à la structure d'adapter ses documents, son accueil et ses démarches.

2. Obstacles : inscription uniquement en ligne ; formulaire de 9 pages ; mots techniques (« quotient familial », « PAI ») ; téléversement d'un PDF ; règlement long en petits caractères, sans image ; horaires d'accueil limités au matin en semaine ; menu sans pictogrammes pour les allergènes ; aucune autre langue que le français.

3. Améliorations : garder le portail mais proposer aussi une inscription papier et un rendez-vous à l'accueil ou par téléphone ; réduire le formulaire à l'essentiel et expliquer chaque mot (« quotient familial : un chiffre calculé par la CAF selon vos revenus ») ; accepter la photo du document prise avec le téléphone ou l'avis remis au guichet ; écrire une version courte du règlement en écriture claire avec pictogrammes ; ouvrir l'accueil un soir par semaine ou le samedi matin ; ajouter les pictogrammes des allergènes au menu ; faire traduire une fiche d'information dans les langues les plus parlées et former une médiatrice ou un adulte relais.

4. Les familles qui réussissent l'inscription en ligne sont surtout celles qui ont un ordinateur, une bonne maîtrise du français écrit et du temps. Les familles les plus modestes, à qui le tarif social est destiné, renoncent plus souvent : c'est le non-recours. L'aide profite alors moins à ceux qui en ont le plus besoin, ce qui creuse le gradient social.

5. Exemple : part des familles des quartiers prioritaires qui bénéficient du tarif social, avant et un an après les changements ; ou nombre d'inscriptions faites à l'accueil et par téléphone.

Corrigé – Exercice 5.5

1. a) Situation : le choc de l'annonce empêche de retenir l'information, quel que soit le niveau d'études. b) Personne, mais avec une bonne littératie interactive : il lit peu, mais il échange et adapte très bien l'information. c) Complexité de l'information : le double affichage « pour 100 g » et « par portion » est difficile même pour une lectrice experte. d) Personne et situation : elle a une bonne littératie en santé dans sa langue ; la difficulté vient de la langue du pays. e) Personne (vue, âge) et complexité des supports (petits caractères, information en ligne).

2. La littératie n'est pas une caractéristique fixe : elle change selon le moment, le stress, la langue, le domaine et la qualité des documents. Parler de situations évite de coller une étiquette aux personnes et rappelle que les professionnels peuvent agir sur la situation et sur les supports.

3. Exemple : « Tu as raison, les difficultés de lecture comptent beaucoup. Mais même une personne diplômée peut ne rien retenir après une mauvaise nouvelle ou ne pas comprendre un tableau nutritionnel. C'est pour ça qu'on écrit simplement et qu'on vérifie la compréhension avec tout le monde : tout le monde y gagne. »

Corrigé – Exercice 5.6

1. Soins : accéder 14 / 60 × 100 = 23,3 % ; comprendre 18 / 60 = 30,0 % ; évaluer 33 / 60 = 55,0 % ; appliquer 12 / 60 = 20,0 %. Prévention : 11 / 60 = 18,3 % ; 21 / 60 = 35,0 % ; 38 / 60 = 63,3 % ; 16 / 60 = 26,7 %. Promotion de la santé : 19 / 60 = 31,7 % ; 17 / 60 = 28,3 % ; 35 / 60 = 58,3 % ; 24 / 60 = 40,0 %.

2. Par compétence (sur 180 réponses) : accéder (14 + 11 + 19) / 180 = 44 / 180 = 24,4 % ; comprendre 56 / 180 = 31,1 % ; évaluer 106 / 180 = 58,9 % ; appliquer 52 / 180 = 28,9 %. Par domaine (sur 240 réponses) : soins 77 / 240 = 32,1 % ; prévention 86 / 240 = 35,8 % ; promotion de la santé 95 / 240 = 39,6 %.

3. La compétence la plus en difficulté est « évaluer » (58,9 %), et la case la plus touchée est « évaluer, en prévention » (63,3 %). L'extrait « Sur internet, chacun dit le contraire… je ne sais plus qui croire » le montre. Comme dans l'enquête HLS19, c'est le jugement de l'information qui pose le plus de problèmes.

4. Exemples : « À la fin de l'action, au moins 70 % des salariés participants sauront citer deux critères pour juger la fiabilité d'une information sur l'alimentation (auteur, source, intérêt commercial) » ; « D'ici un an,

un groupe de salariés aura proposé à la direction au moins deux changements de l'offre alimentaire du site (distributeur, salle de pause), et au moins un sera mis en place. »

5. Esprit critique : atelier « vrai ou faux ? » avec des publications réelles sur le jeûne ou le sans gluten ; les salariés cherchent l'auteur, la date, la source et l'intérêt commercial, puis comparent avec mangerbouger.fr. Pouvoir d'agir : un groupe de travail de salariés de nuit fait un relevé de l'offre du distributeur et prépare des propositions avec le comité social et économique (CSE).

6. Limites : les salariés étaient volontaires, donc l'échantillon n'est pas représentatif (les plus en difficulté ont pu refuser) ; les réponses sont déclaratives (difficulté ressentie, pas mesurée) ; le questionnaire est un court extrait de HLS-EU et ne permet pas de comparer avec les résultats nationaux ; l'effectif de 60 donne des pourcentages peu précis.

Partie 2 – Les données françaises et les enjeux pour la santé publique

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer et interpréter les principales mesures françaises : HLS19, illettrisme, illectronisme.
- Distinguer illettrisme, analphabétisme, français langue étrangère et illectronisme.
- Décrire les conséquences d'une littératie limitée sur la santé et la nutrition.
- Montrer qu'une communication non adaptée peut creuser les inégalités sociales de santé.
- Calculer et interpréter des pourcentages, un écart et un risque relatif.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- HLS19 (réseau M-POHL de l'OMS Europe, résultats français publiés en 2021) : environ 44 % des adultes ont une littératie en santé limitée (environ 30 % « problématique » et 14 % « insuffisante ») ; environ 72 % déclarent des difficultés avec l'information numérique.
- Illettrisme : 7 % des 18-65 ans ayant été scolarisés en France (ANLCI, enquête IVQ 2011). Illectronisme : 7 % des 16-74 ans en 2025 (Insee, 2026) ; 34 % en difficulté numérique.
- Ces chiffres mesurent des choses différentes : on ne les additionne pas.
- Conséquences d'une littératie limitée (Berkman et coll., 2011) : moins de prévention, plus d'hospitalisations, moins bonne compréhension des traitements et gestion des maladies chroniques, mortalité plus élevée chez les personnes âgées.
- Universalisme proportionné (Marmot, 2010) : agir pour tous, avec une intensité et des modalités adaptées aux besoins.

Exercice 5.7 – Légender les mesures françaises et distinguer les notions (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 12 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un diaporama pour une réunion d'élus d'une communauté de communes. Vous voulez présenter trois chiffres sans les mélanger.

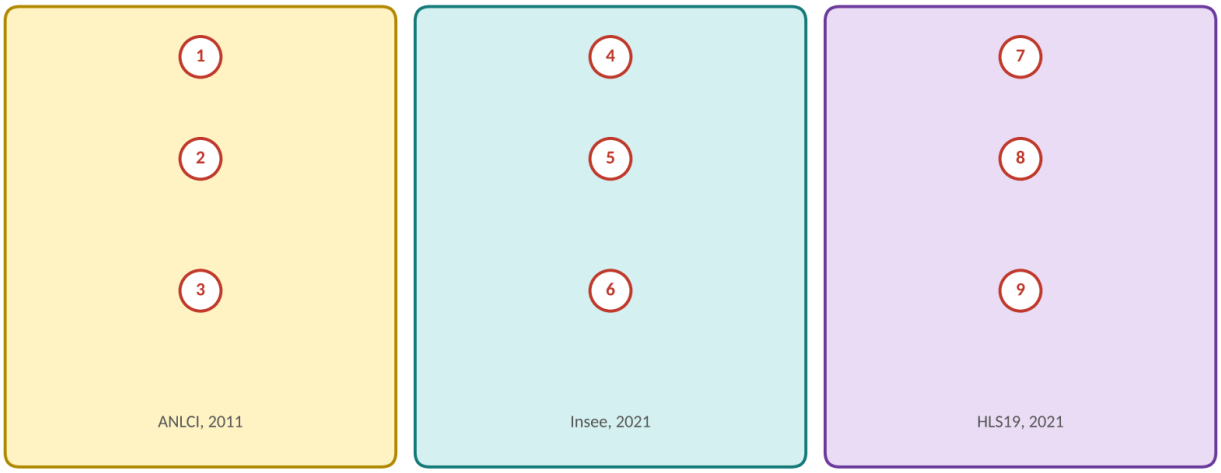


Figure 5.4 – Document 1 – Trois mesures à ne pas confondre (schéma à légender)

Document 2 – Six portraits

a) Mme D., 45 ans, a été à l'école en France jusqu'à 16 ans ; elle déchiffre mal les mots et évite de remplir les formulaires.

b) M. T., 60 ans, n'est jamais allé à l'école ; il ne sait ni lire ni écrire.

c) Mme R., 32 ans, a fait des études de commerce en Syrie ; elle apprend le français depuis un an.

d) M. L., 71 ans, lit très bien mais n'a jamais utilisé internet et n'a pas d'ordinateur.

e) Mme G., 28 ans, lit bien mais trouve très difficile de savoir si un conseil nutritionnel lu en ligne est fiable.

f) M. K., 50 ans, a un smartphone mais ne sait pas remplir un formulaire en ligne ni envoyer un document.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)
2. Associez chaque portrait du document 2 à la notion qui le décrit : illettrisme, analphabétisme, français langue étrangère, illectronisme, littératie en santé limitée. (3 pts)
3. Un élu propose d'additionner les trois chiffres du document 1. Expliquez-lui en deux phrases pourquoi c'est impossible. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.8 – Transposer l'enquête HLS19 à une commune (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une commune de 12 000 adultes (fictive) veut savoir combien d'habitants pourraient avoir du mal avec les informations de santé. Le directeur du CCAS vous demande une estimation à partir des données nationales.

Document 1 – Résultats français de l'enquête HLS19 (publiés en 2021)

- Littératie en santé générale limitée : environ 44 % des adultes.
- Dont littératie « problématique » : environ 30 % ; « insuffisante » : environ 14 %.
- Difficultés avec l'information de santé numérique : environ 72 % des adultes.
- Le niveau est plus bas chez les personnes en difficulté financière, peu diplômées, âgées ou en mauvaise santé.
- Tâches les plus difficiles : juger la fiabilité d'une information dans les médias.

À vous de jouer – Questions

1. Estimez le nombre d'adultes de la commune qui auraient une littératie limitée, puis problématique, puis insuffisante. (3 pts)

2. Estimez le nombre d'adultes qui auraient des difficultés avec l'information numérique. Que pensez-vous du projet de la commune de ne publier le programme de prévention que sur son site ? (2 pts)

3. Donnez deux raisons pour lesquelles cette estimation peut être fausse pour cette commune. (2 pts)

4. Expliquez pourquoi ces données sont « déclaratives » et ce que cela change pour leur interprétation. (2 pts)

5. Dites pourquoi on peut comparer les pays de l'enquête entre eux. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.9 – Le gradient social de la littératie (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un atelier santé ville (fictif) a fait passer un questionnaire court de littératie en santé à 400 adultes de trois quartiers. Il vous confie le tableau des résultats pour préparer le diagnostic.

Document 1 – Littératie en santé limitée selon les difficultés financières déclarées (données fictives)

Difficultés financières	Effectif	Littératie limitée
Très grandes	60	41
Assez grandes	110	58
Faibles	130	49
Aucune	100	22
Total	400	170

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de littératie limitée dans chaque groupe et dans l'ensemble. (3 pts)
2. Calculez combien de fois la littératie limitée est plus fréquente chez les personnes aux très grandes difficultés que chez celles qui n'en ont aucune. (1 pt)
3. Décrivez le résultat en utilisant la notion de gradient social. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi la littératie est à la fois un déterminant de la santé et un médiateur des inégalités. (2 pts)
5. Définissez l'universalisme proportionné et appliquez-le au futur programme de prévention de ces quartiers. (3 pts)
6. Comparez le pourcentage global à la donnée nationale de HLS19 et dites pourquoi la comparaison doit rester prudente. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.10 – Comprendre son plan alimentaire quand on a un diabète (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un réseau d'éducation thérapeutique (fictif) accueille des adultes vivant avec un diabète de type 2. Avant les séances, une infirmière a évalué la littératie des patients avec un questionnaire court, puis leur a demandé d'expliquer leur plan alimentaire avec leurs mots.

Document 1 – Résultats (données fictives)

Littératie en santé	Patients	Expliquent correctement leur plan	Ne l'expliquent pas correctement
Limitée	40	14	26
Suffisante	60	45	15

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque groupe, le pourcentage de patients qui expliquent correctement leur plan, et la différence en points. (3 pts)
2. Calculez le risque relatif de ne pas comprendre son plan quand la littératie est limitée. Le calcul de son intervalle de confiance à 95 % donne [1,59 ; 4,26] : interprétez. (3 pts)
3. Citez trois conséquences d'une littératie limitée décrites par Berkman et coll. (2011). (2 pts)
4. Proposez trois adaptations des séances d'éducation qui profitent à tous les patients. (3 pts)
5. Pourquoi ne faut-il pas annoncer aux patients leur « score de littératie » ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.11 – Une campagne qui creuse les écarts (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une ville (fictive) a mené pendant un an une campagne « 5 fruits et légumes par jour » : une brochure de 12 pages envoyée par courrier et une rubrique sur le site de la ville. L'évaluation donne les résultats ci-dessous.

Document 1 – Part des adultes qui déclarent manger au moins 5 portions par jour (données fictives)

Catégorie	Avant la campagne	Un an après
Cadres et professions intellectuelles	32 %	41 %
Employés	21 %	24 %
Ouvriers et personnes sans emploi	14 %	15 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque catégorie, la progression en points et la progression relative en %. (3 pts)
2. Calculez l'écart en points et le rapport entre cadres et ouvriers avant et après. Concluez. (3 pts)
3. Expliquez ce résultat avec la notion de littératie. (2 pts)
4. Proposez trois changements pour la campagne de l'année suivante, en suivant l'universalisme proportionné. (3 pts)
5. Citez une limite de ces données. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.12 – Le Nutri-Score, un outil pensé pour la littératie (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un stand dans un hypermarché pendant une semaine de prévention. Vous organisez un petit test (fictif) : 90 clients volontaires doivent classer trois pizzas surgelées de la plus favorable à la moins favorable pour la santé. La moitié voit seulement le tableau nutritionnel ; l'autre moitié voit aussi le Nutri-Score.

Document 1 – Nombre de bons classements (données fictives)

Niveau d'études	Effectif par condition	Tableau seul	Tableau et Nutri-Score
Bac ou moins	45	12	33
Plus que le bac	45	24	39

Document 2 – Ce qu'il faut savoir sur le Nutri-Score

Logo facultatif adopté en France en 2017 ; cinq lettres de A (vert foncé) à E (orange foncé) ; algorithme révisé (aliments en 2022, boissons en 2023), appliqué progressivement en France depuis 2024.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de bons classements dans chaque case du document 1. (3 pts)
2. Calculez l'écart entre les deux niveaux d'études avec le tableau seul, puis avec le Nutri-Score. Concluez. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi un logo synthétique et coloré aide plus les personnes à littératie limitée qu'un tableau. (2 pts)
4. Citez deux limites d'usage du Nutri-Score que vous expliquerez aux clients. (2 pts)
5. Rédigez trois phrases courtes pour une affiche du stand, en écriture claire. (2 pts)
6. Citez deux limites de ce test. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 5.7

1. Légendes : 1 Illettrisme ; 2 7 % des 18-65 ans scolarisés en France ; 3 lire, écrire, compter malgré une scolarité en France ; 4 Illectronisme ; 5 7 % des 16-74 ans (2025) ; 6 pas d'usage d'internet ou aucune compétence numérique ; 7 Littératie en santé limitée ; 8 environ 44 % des adultes ; 9 difficulté à trouver, comprendre, juger, utiliser l'information de santé.
2. a) illettrisme (scolarisée en France, maîtrise insuffisante) ; b) analphabétisme (jamais scolarisé) ; c) français langue étrangère (scolarisée dans une autre langue, bonne littératie dans sa langue) ; d) illectronisme (pas d'usage d'internet) ; e) littératie en santé limitée (difficulté à juger l'information, alors qu'elle lit bien) ; f) illectronisme (pas de compétences numériques de base malgré l'équipement).
3. Les trois chiffres ne mesurent pas la même chose et ne portent pas sur la même population (18-65 ans scolarisés en France, 16-74 ans, adultes). Une même personne peut être comptée dans deux ou trois mesures ; additionner les pourcentages compterait plusieurs fois les mêmes personnes.

Corrigé – Exercice 5.8

1. Littératie limitée : 12 000 × 44 / 100 = 5 280 adultes. Problématique : 12 000 × 0,30 = 3 600. Insuffisante : 12 000 × 0,14 = 1 680. On vérifie : 3 600 + 1 680 = 5 280.
2. 12 000 × 0,72 = 8 640 adultes. Publier le programme uniquement en ligne exclurait une grande partie des habitants ; il faut plusieurs canaux : affiches, courrier simple, relais (pharmacies, écoles, associations), oral.
3. La commune n'a pas forcément la même structure que la France : plus de personnes âgées, plus de difficultés financières ou au contraire une population plus diplômée. Les données nationales datent de 2019-2021 et la situation a pu évoluer.
4. Les personnes disent si une tâche leur paraît facile ou difficile : on mesure une difficulté ressentie, pas une compétence testée. Certaines personnes peuvent surestimer ou sous-estimer leurs capacités ; on interprète donc ces chiffres comme des ordres de grandeur.
5. Les 17 pays ont utilisé le même questionnaire et la même méthode, sous la coordination du réseau M-POHL.

Corrigé – Exercice 5.9

1. Très grandes : 41 / 60 × 100 = 68,3 % ; assez grandes : 58 / 110 = 52,7 % ; faibles : 49 / 130 = 37,7 % ; aucune : 22 / 100 = 22,0 % ; ensemble : 170 / 400 = 42,5 %.
2. 68,3 / 22,0 = 3,1 : la littératie limitée est environ trois fois plus fréquente.
3. La littératie limitée diminue de façon régulière à chaque niveau de difficulté financière, de 68,3 % à 22,0 %. Ce n'est pas seulement le groupe le plus pauvre qui est touché : c'est toute l'échelle sociale qui suit une pente, c'est un gradient social.
4. Déterminant : une littératie limitée rend plus difficile l'accès à la prévention et la gestion des maladies. Médiateur : les personnes défavorisées ont plus souvent une littératie limitée, et une partie de leur moins bonne santé passe par cette difficulté à utiliser l'information.
5. L'universalisme proportionné (Marmot, 2010) consiste à proposer une action à toute la population, avec une intensité et des modalités adaptées au niveau de besoin. Ici : un programme ouvert à tous, avec des supports en écriture claire pour tous ; dans les quartiers où les difficultés sont les plus fortes, des ateliers en plus, des relais habitants, une médiatrice, des séances orales et des rappels par message vocal.
6. 42,5 % est proche des 44 % nationaux ; mais le questionnaire local n'est pas celui de HLS19 et l'échantillon n'est pas forcément représentatif : la comparaison reste indicative.

Corrigé – Exercice 5.10

1. Littératie limitée : 14 / 40 × 100 = 35,0 % ; suffisante : 45 / 60 × 100 = 75,0 % ; différence : 75,0 − 35,0 = 40 points.
2. Risque de ne pas comprendre : limitée 26 / 40 = 65,0 % ; suffisante 15 / 60 = 25,0 % ; RR = 65,0 / 25,0 = 2,6. Les patients à littératie limitée ont 2,6 fois plus de risque de ne pas comprendre leur plan. L'intervalle [1,59 ; 4,26] ne contient pas 1 : l'association est statistiquement significative au seuil de 5 %.
3. Moindre compréhension des traitements et des conseils ; moins bonne gestion des maladies chroniques comme le diabète ; davantage d'hospitalisations et de passages aux urgences ; moindre recours à la prévention.
4. Un seul message par séance, en mots simples ; des objets réels (assiette, aliments, emballages, cuillères) et des photos ; la vérification de la compréhension par le « faire dire » ; un support à emporter en images ; la possibilité de venir avec un proche.
5. Annoncer un score étiquette la personne, provoque la honte et peut la faire partir du programme. Le score sert à l'équipe pour adapter les séances, pas à juger le patient.

Corrigé – Exercice 5.11

1. Cadres : + 9 points, soit 9 / 32 × 100 = + 28,1 % ; employés : + 3 points, soit + 14,3 % ; ouvriers et sans emploi : + 1 point, soit + 7,1 %.
2. Avant : écart 32 − 14 = 18 points, rapport 32 / 14 = 2,29. Après : écart 41 − 15 = 26 points, rapport 41 / 15 = 2,73. La campagne a amélioré la situation de tous, mais elle a surtout profité aux plus favorisés : les inégalités se sont creusées.
3. Une brochure de 12 pages et un site internet demandent une bonne littératie fonctionnelle et numérique. Les personnes qui lisent facilement et utilisent internet ont reçu et compris le message ; les autres l'ont moins reçu et moins compris.
4. Exemples : remplacer la brochure par une affiche à un seul message (« une portion = un poing ») et des cartes recettes en photos ; ajouter des actions de proximité dans les quartiers les plus touchés (dégustations au marché, ateliers en centre social, paniers à petit prix) ; passer par des relais (écoles, médiateurs, associations) et des messages oraux ; agir sur le prix et l'offre (bons d'achat, marché à prix solidaires).
5. Les données sont déclaratives : les personnes peuvent surestimer leur consommation, surtout après une campagne qui parle de ce sujet.

Corrigé – Exercice 5.12

1. Bac ou moins : tableau seul 12 / 45 × 100 = 26,7 % ; avec Nutri-Score 33 / 45 = 73,3 %. Plus que le bac : 24 / 45 = 53,3 % ; 39 / 45 = 86,7 %.
2. Avec le tableau seul, l'écart est de 53,3 − 26,7 = 26,6 points. Avec le Nutri-Score, il n'est plus que de 86,7 − 73,3 = 13,4 points. Le logo aide tout le monde, mais il aide davantage les personnes moins diplômées : il réduit l'écart.
3. Le tableau demande de lire des chiffres pour 100 g, de connaître les nutriments et de comparer plusieurs lignes. Le logo résume l'information en une lettre et une couleur, compréhensibles sans calcul et en quelques secondes.
4. On compare des produits d'une même famille (deux pizzas, pas une pizza et une pomme) ; on regarde aussi la liste d'ingrédients et la taille de la portion ; le logo est facultatif et n'est pas présent sur tous les produits.
5. Exemple : « Comparez deux pizzas. Choisissez la lettre la plus proche du A. Regardez aussi la liste des ingrédients. »
6. Les clients sont volontaires et peu nombreux ; le test porte sur une seule famille de produits ; on mesure un classement en situation de test, pas un achat réel au magasin.

Partie 3 – Repérer sans stigmatiser et adapter le diagnostic

Objectifs – Objectifs de la partie

- Expliquer l'approche des précautions universelles.
- Reconnaître des signaux possibles de difficulté, sans les interpréter comme une preuve.
- Poser des questions simples pour adapter la communication, sans juger.
- Adapter un outil de diagnostic (questionnaire oral, pictogrammes, médiation).
- Comparer deux modes de passation avec des taux de retour et de réponses exploitables.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- On ne peut pas savoir en regardant quelqu'un s'il a des difficultés de littératie ; les personnes les cachent souvent par honte.
- Précautions universelles (AHRQ) : appliquer à tous une communication claire, au lieu de tester le public. Tout le monde y gagne, personne n'est désigné.
- Signaux possibles : évitement de l'écrit (« j'ai oublié mes lunettes »), difficultés avec les chiffres, questions sur ce qui est déjà écrit, questionnaires non remplis, absence d'adresse mail.
- Questions qui aident sans juger : « Comment préférez-vous recevoir les informations ? », « Quelqu'un vous aide-t-il pour les papiers ? », « Dans quelle langue êtes-vous le plus à l'aise ? »
- Au diagnostic : préférer la passation orale ou imagée au questionnaire écrit autoadministré quand le public lit difficilement.

Exercice 5.13 – Vrai ou faux : les précautions universelles (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un quiz pour des bénévoles d'une association d'aide alimentaire qui vont accueillir les bénéficiaires d'un atelier cuisine.

Document 1 – Huit affirmations

a) Pour bien adapter un atelier, il faut d'abord faire passer un test de lecture à chaque participant.

b) Une personne qui dit « j'ai oublié mes lunettes » a forcément des difficultés de lecture.

c) Une écriture claire gêne les personnes qui lisent bien.

d) Les précautions universelles consistent à communiquer clairement avec tout le monde.

e) Les personnes en difficulté avec l'écrit le disent spontanément.

f) Proposer de lire le document à voix haute à tout le groupe évite de désigner quelqu'un.

g) Un questionnaire oral peut remplacer un questionnaire écrit autoadministré.

h) Demander « Dans quelle langue êtes-vous le plus à l'aise ? » est une question stigmatisante.

À vous de jouer – Questions

1. Dites si chaque affirmation est vraie ou fausse et justifiez en une phrase. (8 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.14 – Les signaux à l'accueil d'une épicerie solidaire (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans une épicerie solidaire (fictive). Pendant l'accueil, vous observez les échanges entre une bénévole et des bénéficiaires.

Document 1 – Notes d'observation

a) Mme B. tend le formulaire d'inscription à sa fille de 12 ans pour qu'elle le remplisse.

b) M. C. demande : « Le prix au kilo, c'est pour combien de paquets ? »

c) Mme F. prend la fiche recette et dit : « Je la lirai chez moi. »

d) M. H. n'a pas d'adresse mail et dit qu'il utilise son téléphone « seulement pour appeler ».

e) La bénévole dit à voix haute devant la file d'attente : « Ah, vous ne savez pas lire ? Je vais vous aider. »

f) Mme K. demande quand a lieu l'atelier, alors que la date est écrite en gros sur l'affiche à côté d'elle.

À vous de jouer – Questions

1. Pour les situations a), b), c), d) et f), nommez le signal possible observé. (2,5 pts)
2. Expliquez pourquoi ces signaux ne sont pas des preuves. Donnez une autre explication possible pour deux d'entre eux. (2,5 pts)
3. Analysez la phrase de la bénévole en e) et ses conséquences possibles. (2 pts)
4. Proposez trois changements simples de l'accueil qui suivent les précautions universelles. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.15 – Réécrire un questionnaire de diagnostic (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse et production · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de quartier (fictive) veut connaître les habitudes de petit-déjeuner des familles avant de lancer un projet. L'an dernier, elle a distribué un questionnaire écrit dans les cartables. Vous devez le refaire.

Document 1 – Extrait du questionnaire de l'an dernier

Q1. Quelle est la fréquence hebdomadaire de prise du petit-déjeuner de votre enfant ?

Q2. Votre enfant consomme-t-il des produits céréaliers complets et/ou des produits laitiers non sucrés au cours de cette prise alimentaire ?

Q3. Estimez-vous que le petit-déjeuner contribue à la couverture des besoins nutritionnels de votre enfant ? (pas du tout / peu / moyennement / assez / tout à fait)

Q4. Quels sont les freins à la prise d'un petit-déjeuner équilibré au domicile ?

Q5. Seriez-vous intéressé(e) par une action collective de type atelier de sensibilisation ?

Q6. Merci de retourner ce questionnaire complété à l'enseignant sous 8 jours.

Document 2 – Bilan de l'an dernier

140 questionnaires distribués ; 23 retournés, dont 9 incomplets.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de retour, la part de questionnaires incomplets parmi les retours et la part de questionnaires exploitables sur l'ensemble des questionnaires distribués. (2 pts)
2. Relevez quatre défauts de rédaction du document 1. (2 pts)
3. Réécrivez les questions Q1, Q2, Q4 et Q5 pour une passation orale, avec des mots courants et des réponses simples. (4 pts)
4. Proposez une version imagée de la question Q2 (décrivez les images et la consigne). (2 pts)
5. Proposez deux autres moyens de recueillir l'information auprès des familles. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.16 – Questionnaire écrit ou passation orale ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Suite de l'exercice 5.15. Cette année, la maison de quartier a testé une passation orale à la sortie de l'école, menée par une médiatrice qui parle français, arabe et turc. Vous devez comparer les deux méthodes pour la direction.

Document 1 – Comparaison (données fictives)

	Questionnaire écrit (an dernier)	Passation orale (cette année)
Familles sollicitées	140	75
Réponses obtenues	23	60
Réponses complètes	14	57
Durée par réponse	—	12 minutes
Coût	impression 0,12 € par questionnaire	médiatrice 22 € de l'heure

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour la passation orale, le taux d'acceptation, la part de réponses complètes parmi les réponses et la part de réponses exploitables parmi les familles sollicitées. Comparez avec l'écrit (exercice 5.15). (3 pts)
2. Calculez le temps total de passation orale en heures et son coût, puis le coût par réponse exploitable pour chaque méthode. (3 pts)
3. Argumentez en faveur de la passation orale, en tenant compte du coût. (3 pts)
4. Citez deux biais possibles de la passation orale et la façon de les limiter. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi un taux de retour faible à l'écrit fausse le diagnostic. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.17 – Poser les bonnes questions sans juger (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse et production · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous formez les animateurs d'un centre social à l'accueil des participants d'un nouvel atelier cuisine. Vous avez relevé les questions qu'ils posent en ce moment lors de l'inscription.

Document 1 – Questions posées par les animateurs

a) « Vous savez lire ? »

b) « Vous avez internet, comme tout le monde ? »

c) « Vous comprenez le français ? »

d) « Je vous donne le règlement, vous signez en bas après l'avoir lu. »

e) « Vous avez bien compris ? »

f) « Comment préférez-vous qu'on vous prévienne pour les ateliers ? »

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque question : adaptée ou à éviter. Justifiez. (3 pts)
2. Réécrivez les questions à éviter pour qu'elles aident à adapter l'accueil sans juger. (5 pts)
3. Expliquez ce que l'animateur doit faire de la réponse à la question f). (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.18 – Diagnostic dans une résidence sociale (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une résidence sociale (fictive), ancien foyer de travailleurs migrants, accueille 52 hommes âgés de 55 à 84 ans. Chaque étage a une cuisine collective. L'infirmière qui passe chaque semaine s'inquiète de repas répétitifs et de cas de diabète. Le gestionnaire vous demande de préparer un projet. Vous avez fait un premier recueil avec le responsable de la résidence.

Document 1 – Premier recueil (n = 52, données fictives)

Caractéristique	Effectif
Langue la plus utilisée : arabe	31
Langue la plus utilisée : soninké ou bambara	9
Langue la plus utilisée : français	12
Lit peu ou pas le français	27
A un téléphone mobile	44
Utilise WhatsApp	18
Cuisine dans la cuisine collective	46
Signale des problèmes de vue non corrigés	15

Document 2 – Paroles recueillies

- « Les papiers, c'est mon voisin qui me les lit. »
- « On cuisine ensemble au troisième, chacun met 3 € et on fait un grand plat. »
- « Le médecin m'a donné une feuille pour le diabète. Je l'ai gardée, mais je ne l'ai pas lue. »
- « Le mardi, après la prière, tout le monde est dans la salle commune. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de chaque caractéristique du document 1. (4 pts)
2. À partir des documents, dites quels éléments de littératie le diagnostic doit encore recueillir et comment les recueillir sans questionnaire écrit. (3 pts)
3. Identifiez trois ressources du milieu sur lesquelles le projet peut s'appuyer. (3 pts)
4. Proposez deux canaux pour inviter les résidents à la première rencontre. Justifiez avec les chiffres. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi la feuille sur le diabète n'a pas été utile, et ce que le projet peut faire avec l'infirmière et le médecin. (2 pts)
6. Citez deux précautions éthiques pour ce diagnostic. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 5.13

a) Faux : tester les personnes est vécu comme humiliant et inutile ; on adapte la communication pour tous. b) Faux : c'est un signal possible, mais la personne a peut-être vraiment oublié ses lunettes. c) Faux : une écriture claire est plus rapide et plus agréable à lire pour tout le monde. d) Vrai : c'est la définition des précautions universelles (AHRQ). e) Faux : les difficultés sont souvent cachées par honte ; on ne peut pas attendre qu'elles soient dites. f) Vrai : la lecture collective aide tout le monde sans désigner personne. g) Vrai : la passation orale ou en entretien convient mieux aux publics qui lisent peu et donne des réponses plus complètes. h) Faux : c'est une question neutre et respectueuse qui aide à choisir la bonne langue ou un interprète.

Corrigé – Exercice 5.14

1. a) évitement de l'écrit (formulaire rempli par un proche) ; b) difficulté avec les chiffres (prix au kilo) ; c) évitement de l'écrit (« je la lirai chez moi ») ; d) difficultés numériques (pas de mail, téléphone pour appeler) ; f) question sur une information déjà écrite.
2. Un signal peut avoir d'autres causes ; seul, il ne prouve rien et on ne pose pas de diagnostic sur une personne. Exemples : en a), Mme B. a peut-être mal aux yeux ou veut apprendre à sa fille à remplir un document ; en c), Mme F. est peut-être pressée ; en f), elle veut peut-être simplement engager la conversation.
3. La bénévole révèle devant tout le monde une difficulté supposée : c'est humiliant et stigmatisant. La personne risque de ne pas revenir, et d'autres personnes en difficulté n'oseront plus demander d'aide. La phrase est aussi peut-être fausse.
4. Exemples : lire à voix haute les informations importantes à tous les nouveaux inscrits ; proposer à tous de remplir le formulaire ensemble, dans un coin calme ; afficher les dates avec un calendrier en images et les rappeler à l'oral ; remettre des fiches recettes en photos ; former les bénévoles à des phrases neutres (« Je remplis avec vous, c'est plus rapide »).

Corrigé – Exercice 5.15

1. Taux de retour : 23 / 140 × 100 = 16,4 %. Incomplets parmi les retours : 9 / 23 × 100 = 39,1 %. Exploitables sur l'ensemble : (23 − 9) / 140 = 14 / 140 × 100 = 10,0 %.
2. Défauts : vocabulaire technique (« fréquence hebdomadaire », « produits céréaliers complets », « couverture des besoins nutritionnels », « freins ») ; questions longues et doubles (Q2 mélange deux sujets avec « et/ou ») ; échelle à cinq niveaux difficile à utiliser ; Q5 utilise un jargon (« action collective », « sensibilisation ») ; retour par écrit via l'enseignant, sans aide.
3. Exemples : Q1 « Combien de matins par semaine votre enfant mange-t-il avant l'école ? (jamais, 1 à 3 matins, 4 à 6 matins, tous les matins) » ; Q2 « Le matin, qu'est-ce qu'il mange et qu'est-ce qu'il boit ? » (l'enquêtrice coche dans une liste) ; Q4 « Qu'est-ce qui rend le petit-déjeuner difficile chez vous ? Par exemple le temps, l'envie de l'enfant, le prix » ; Q5 « Aimeriez-vous venir à un moment entre parents pour préparer des petits-déjeuners ensemble ? (oui, non, peut-être) ».
4. Exemple : une planche de 12 photos réelles (pain, céréales, biscuits, fruit, lait, yaourt, jus, soda, chocolat en poudre, rien…) ; consigne orale : « Montrez-moi les photos de ce que votre enfant a mangé et bu ce matin. » L'enquêtrice note les numéros.
5. Exemples : des entretiens courts avec des parents à la sortie de l'école ; un groupe de parole autour d'un petit-déjeuner partagé ; l'observation d'un petit-déjeuner pris à l'accueil du matin ; un photolangage.

Corrigé – Exercice 5.16

1. Taux d'acceptation : 60 / 75 × 100 = 80,0 %. Réponses complètes parmi les réponses : 57 / 60 = 95,0 %.

Exploitables parmi les familles sollicitées : 57 / 75 = 76,0 %. À l'écrit : 16,4 % de retour, 60,9 % de réponses complètes (14 / 23) et 10,0 % d'exploitables. L'oral donne 7,6 fois plus de réponses exploitables en proportion (76,0 / 10,0).

2. Temps : 60 × 12 = 720 minutes, soit 12 heures. Coût : 12 × 22 = 264 €. Écrit : 140 × 0,12 = 16,80 €, soit 16,80 / 14 = 1,20 € par réponse exploitable. Oral : 264 / 57 = 4,63 € par réponse exploitable.

3. L'oral coûte plus cher, mais il donne 57 réponses complètes au lieu de 14 et il touche les familles qui ne répondent jamais à l'écrit, souvent celles qui ont le plus besoin du projet. Un diagnostic fondé sur 14 réponses ne représente pas le quartier. La médiatrice crée aussi un premier lien de confiance et fait connaître le projet. Le coût reste raisonnable (moins de 5 € par réponse).

4. Biais de désirabilité sociale (on répond ce que l'on pense être attendu) : questions neutres, sans jugement, enquêtrice formée. Biais de l'enquêteur (formulation variable, traduction différente) : grille commune, mêmes mots, traduction préparée à l'avance. On peut aussi citer le biais de sélection (seules les familles présentes à la sortie de l'école sont interrogées) : varier les horaires et les lieux.

5. Les familles qui répondent à l'écrit sont surtout celles qui lisent facilement et qui ont du temps : le diagnostic décrit alors une partie seulement du public, souvent la plus favorisée. C'est un biais de sélection.

Corrigé – Exercice 5.17

1. a) À éviter : humiliante, elle désigne la personne et appelle souvent un « oui » de gêne. b) À éviter : « comme tout le monde » juge et met mal à l'aise. c) À éviter : question fermée qui peut vexer ; mieux vaut demander la langue préférée. d) À éviter : suppose que la personne lit le règlement et la fait signer sans comprendre. e) À éviter : appelle presque toujours « oui » ; ne vérifie rien. f) Adaptée : ouverte, neutre, elle laisse la personne choisir.

2. a) « Pour les papiers, vous préférez qu'on les remplisse ensemble ou que vous les preniez avec vous ? » b) « Comment voulez-vous qu'on vous prévienne : par téléphone, par message, par papier ? » c) « Dans quelle langue êtes-vous le plus à l'aise ? Nous pouvons demander à une médiatrice de venir. » d) « Je vous explique les quatre règles importantes, avec les images. Ensuite, vous me dites si vous avez des questions, et on signe ensemble. » e) « Pour être sûr d'avoir bien expliqué, pouvez-vous me dire ce que vous apportez à l'atelier de mardi ? »

3. Il note la réponse dans la fiche d'inscription et la respecte : appel la veille, message vocal, carte papier. Il ne choisit pas à la place de la personne, et il ne réserve pas l'information au numérique.

Corrigé – Exercice 5.18

1. Arabe 31 / 52 × 100 = 59,6 % ; soninké ou bambara 9 / 52 = 17,3 % ; français 12 / 52 = 23,1 % ; lit peu ou pas le français 27 / 52 = 51,9 % ; téléphone mobile 44 / 52 = 84,6 % ; WhatsApp 18 / 52 = 34,6 % ; cuisine collective 46 / 52 = 88,5 % ; problèmes de vue non corrigés 15 / 52 = 28,8 %.

2. À recueillir : la lecture dans la langue d'origine (certains lisent l'arabe), la compréhension orale du français, les habitudes de repas et de courses, les connaissances sur le diabète et ce qui a été compris des consignes du médecin, la vue (lunettes). Méthodes : entretiens individuels avec un interprète ou un résident relais ; un groupe de parole dans la salle commune le mardi ; l'observation d'une préparation de repas dans une cuisine d'étage, avec l'accord des résidents.

3. Ressources : la cuisine collective et l'organisation déjà en place (« chacun met 3 € ») ; l'entraide entre voisins (le voisin qui lit les papiers peut devenir relais) ; le rendez-vous du mardi dans la salle commune ; l'infirmière qui connaît les résidents ; le responsable de la résidence.

4. Une annonce orale le mardi dans la salle commune, faite par un résident relais en arabe, en soninké et en français, car 51,9 % lisent peu le français et le rendez-vous rassemble « tout le monde ». Un appel ou un message vocal sur le téléphone, car 84,6 % ont un mobile ; WhatsApp seul ne suffit pas (34,6 %). Une affiche avec un pictogramme et une photo peut compléter, avec de gros caractères (28,8 % ont des problèmes de vue).

5. La feuille est écrite en français, sans doute avec des mots techniques, et remise sans vérification de la compréhension ; le résident ne la lit pas. Le projet peut proposer avec l'infirmière des séances orales sur le diabète avec des aliments réels, traduire les messages clés avec un interprète professionnel, demander au médecin des consignes courtes et en images, et vérifier la compréhension par le « faire dire ».

6. Recueillir le consentement libre de chaque résident et expliquer à quoi servent les informations ; garantir la confidentialité (ne pas parler du diabète d'un résident devant les autres) ; ne pas utiliser un voisin comme interprète pour des informations médicales personnelles ; ne pas présenter les résultats d'une façon qui stigmatise les résidents.

Partie 4 – Écrire clair, FALC et mesure de la lisibilité

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer dans l'ordre les six étapes d'une communication accessible.
- Appliquer les règles d'écriture claire du guide « Communiquer pour tous » (Santé publique France, 2018).
- Définir le FALC et dire qui valide un document FALC.
- Calculer et interpréter l'indice de lisibilité de Kandel et Moles (1958).
- Citer les limites de l'indice et montrer que le test auprès du public reste indispensable.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Six étapes : connaître le public, choisir un message, écrire simple, illustrer, tester, vérifier par le « faire dire ».
- Écriture claire : une idée par phrase, 15 mots au plus ; mots courants ; forme active ; phrases positives ; chiffres concrets ; pas de sigles ; police sans empattement de 14 points au moins, alignée à gauche ; images utiles.
- FALC (Facile à lire et à comprendre) : règles européennes (Inclusion Europe, 2009), conçu avec et pour les personnes en situation de handicap intellectuel ; document relu et validé par des personnes concernées.
- L = 207 − 1,015 × (mots / phrases) − 73,6 × (syllabes / mots). Échelle : 0-30 très difficile ; 30-50 difficile ; 50-60 assez difficile ; 60-70 standard ; 70-80 assez facile ; 80-90 facile ; 90-100 très facile.
- L'indice ne mesure ni le sens, ni la mise en page, ni l'adéquation au public.

Exercice 5.19 – Les six étapes d'une communication accessible (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 12 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une collègue doit concevoir une affiche sur l'hydratation pour un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Elle vous demande de lui rappeler la méthode.

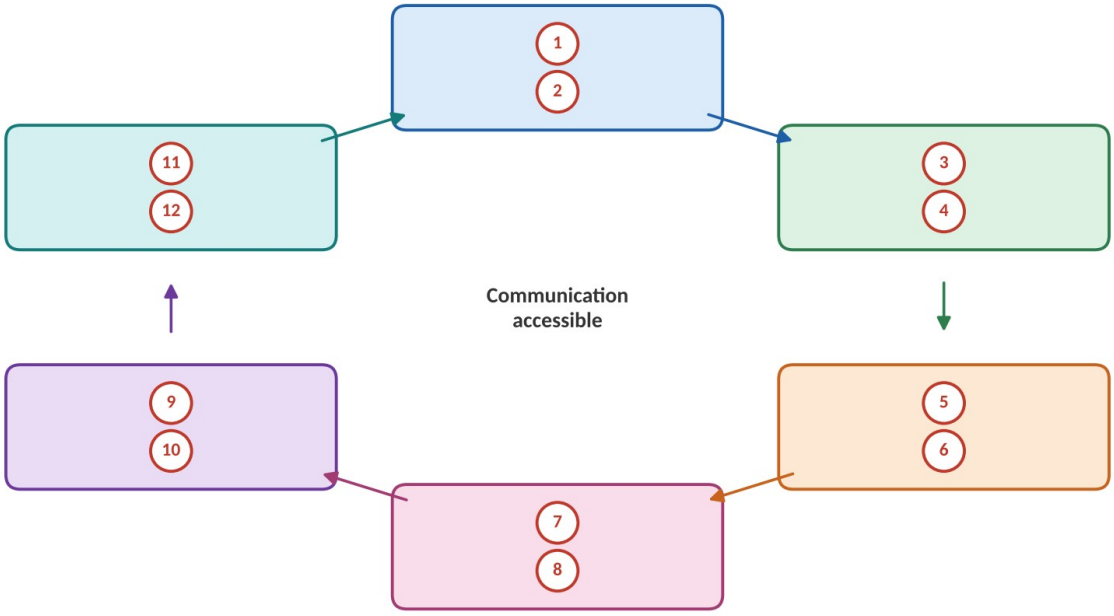


Figure 5.5 – Document 1 – Six étapes pour une communication accessible (schéma à légender)

Document 2 – Ce que la collègue a prévu, dans le désordre

a) Montrer l'affiche à cinq résidents et à deux aides-soignantes avant de l'imprimer.

b) Ajouter la photo d'un verre d'eau et d'une carafe posés sur une table de chambre.

c) Garder un seul message : « Buvez un verre d'eau à chaque repas et entre les repas. »

d) Demander aux résidents, après la présentation, de dire avec leurs mots quand ils vont boire.

e) Se renseigner sur la vue, l'audition et les troubles de la mémoire des résidents.

f) Remplacer « hydratation » par « boire » et « 1,5 L » par « 6 à 8 verres ».

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (6 pts)
2. Remettez les actions du document 2 dans l'ordre des six étapes. (3 pts)
3. Dites pourquoi l'étape « tester » se place avant l'impression. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.20 – Calculer et situer trois indices de lisibilité (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous devez choisir, pour un atelier en centre social, le texte le plus facile parmi trois présentations d'une recette de soupe. Vous avez compté les mots, les phrases et les syllabes.

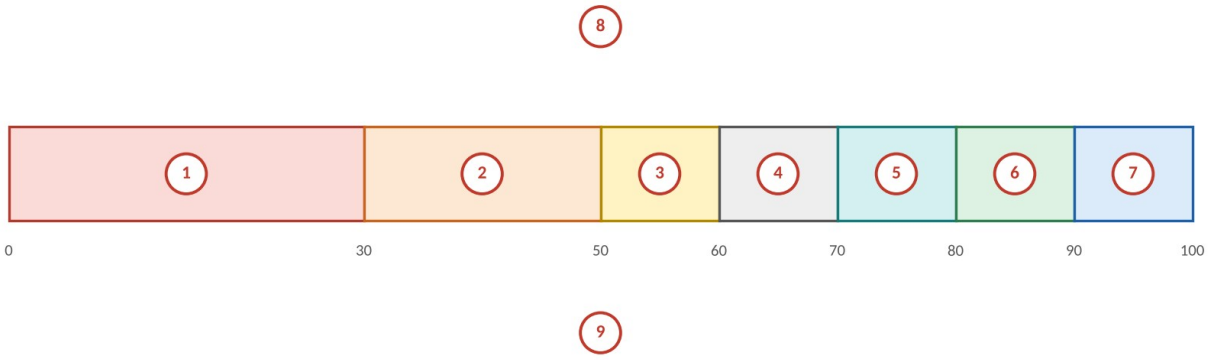


Figure 5.6 – Document 1 – L'échelle de lisibilité (schéma à légender)

Document 2 – Comptages des trois textes

Texte	Mots	Phrases	Syllabes
A	84	4	150
B	60	8	84
C	45	2	90

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (3 pts)
2. Calculez, pour chaque texte, le nombre de mots par phrase, le nombre de syllabes par mot (au millième) et l'indice L (au centième). (4,5 pts)
3. Situez chaque texte sur l'échelle et choisissez le texte pour l'atelier. (1,5 pt)
4. Le texte C est le plus court. Expliquez pourquoi il est pourtant le plus difficile. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.21 – Appliquer les règles d'écriture claire (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mutuelle (fictive) prépare un dépliant « Bien manger avec un petit budget ». Elle vous demande de relire huit phrases.

Document 1 – Les huit phrases du dépliant

a) Il est recommandé de privilégier la consommation de légumineuses au moins deux fois par semaine.

b) Ne pas oublier de consulter les DLC et les DDM avant d'acheter.

c) Les AGS doivent être limités au profit des AGPI oméga-3.

d) Une consommation de 400 g de fruits et légumes par jour est conseillée par l'OMS.

e) Il convient d'éviter de jeter les restes, dans la mesure où ils peuvent être réutilisés dans des préparations ultérieures, par exemple des soupes ou des gratins, ce qui permet de réaliser des économies.

f) LES PRODUITS DE SAISON SONT MOINS CHERS.

g) Les produits ultra-transformés ne sont pas à privilégier.

h) Le pain complet présente une teneur en fibres supérieure.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque phrase, nommez la ou les règles d'écriture claire qui ne sont pas respectées. (4 pts)
2. Réécrivez chaque phrase en écriture claire. (8 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.22 – La lettre aux familles sur le goûter (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une école élémentaire (fictive) veut que les familles apportent des goûters variés pour la récréation de l'après-midi à l'accueil périscolaire. La première lettre n'a rien changé. Vous l'avez réécrite avec deux mamans du conseil d'école, puis vous avez testé les deux versions.

Document 1 – Extrait de la première version

« Dans le cadre de la démarche de promotion de la santé engagée par l'établissement en partenariat avec la commune, nous sollicitons votre collaboration afin de favoriser la diversification des collations apportées par les élèves lors du temps périscolaire, en privilégiant les fruits frais, les produits céréaliers peu sucrés et les produits laitiers non aromatisés, au détriment des produits de biscuiterie industrielle et des boissons sucrées. »

Document 2 – Comptages et test de compréhension

- Première version (lettre entière) : 186 mots, 6 phrases, 320 syllabes.
- Version réécrite : 98 mots, 11 phrases, 147 syllabes, 4 photos de goûters.
- Test auprès de 12 parents : « Citez deux goûters conseillés par l'école. » Première version : 5 bonnes réponses ; version réécrite : 11 bonnes réponses.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'indice de lisibilité de chaque version (mots par phrase, syllabes par mot, L) et le gain. Situez chaque version sur l'échelle. (5 pts)
2. Calculez le taux de bonnes réponses au test pour chaque version. (2 pts)
3. Relevez dans le document 1 quatre éléments qui rendent la lettre difficile. (2 pts)
4. Rédigez le début de la version réécrite : un titre et quatre phrases. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi le test auprès des parents est plus important que l'indice. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.23 – Un menu en FALC pour un ESAT (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – production · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un établissement et service d'accompagnement par le travail (ESAT, fictif) emploie 60 travailleurs en situation de handicap intellectuel. Le restaurant de l'ESAT affiche chaque jour son menu. Le directeur souhaite que les travailleurs puissent le lire seuls et choisir leur plat.

Document 1 – Le menu actuel

« Menu du jeudi : Velouté Du Barry ; Émincé de volaille sauce suprême ou Dos de colin, beurre blanc ; Accompagnements : riz pilaf / poêlée de légumes ; Fromage AOP ou Laitage ; Dessert : Crumble pomme-rhubarbe. Allergènes : se renseigner auprès du personnel. »

À vous de jouer – Questions

1. Définissez le FALC et dites d'où viennent ses règles. (2 pts)
2. Relevez cinq difficultés du menu actuel pour les travailleurs de l'ESAT. (2,5 pts)
3. Réécrivez le menu en FALC : mots, présentation, images à prévoir. (4 pts)
4. Expliquez qui doit relire et valider ce menu, et pourquoi. (2 pts)
5. Citez une ressource FALC existante en santé et deux autres publics à qui ce menu sera utile. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.24 – Les limites de l'indice de lisibilité (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – argumentation · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire a calculé l'indice de lisibilité de trois fiches pour un atelier « diabète et alimentation » d'une association de patients. Elle conclut : « Les fiches 1 et 2 ont le même indice, elles sont aussi faciles l'une que l'autre. »

Document 1 – Extraits et comptages

- Fiche 1 (60 mots, 6 phrases, 90 syllabes) : « Le pain complet cale plus longtemps. Mangez-en le matin. Les légumes vont à chaque repas… »
- Fiche 2 (60 mots, 6 phrases, 90 syllabes) : « Visez un IG bas. Le pain T150 est OK. Évitez les AGS et les GL hauts… »
- Fiche 3 (72 mots, 3 phrases, 115 syllabes), mise en page aérée avec 5 photos.
- Test auprès de 10 membres de l'association : « Que mangez-vous au petit-déjeuner pour être rassasié jusqu'à midi ? » Fiche 1 : 9 bonnes réponses ; fiche 2 : 3 ; fiche 3 : 8.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'indice L des trois fiches. (3 pts)

2. Calculez le taux de bonnes réponses au test pour chaque fiche. (1,5 pt)

3. Expliquez pourquoi les fiches 1 et 2 ont le même indice mais pas la même compréhension. (2,5 pts)

4. Expliquez pourquoi la fiche 3, moins lisible selon l'indice, est bien comprise. (2 pts)

5. Rédigez un paragraphe de conseil à la stagiaire sur le bon usage de l'indice. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 5.19

1. Légendes : 1 Connaître le public ; 2 langue, écrit, numérique, handicap ; 3 Choisir un message ; 4 un message principal, trois idées au plus ; 5 Écrire simple ; 6 phrases courtes, mots courants, chiffres concrets ; 7 Illustrer ; 8 pictogrammes, photos, objets réels ; 9 Tester ; 10 auprès de personnes du public, avant de diffuser ; 11 Vérifier ; 12 faire dire en séance.
2. Ordre : e) connaître le public ; c) choisir un message ; f) écrire simple ; b) illustrer ; a) tester ; d) vérifier.
3. Tester avant l'impression permet de corriger les mots ou les images mal compris sans réimprimer, donc sans perdre d'argent ni diffuser un message mal compris.

Corrigé – Exercice 5.20

1. Légendes : 1 très difficile ; 2 difficile ; 3 assez difficile ; 4 standard ; 5 assez facile ; 6 facile ; 7 très facile ; 8 L = 207 − 1,015 × (mots / phrases) − 73,6 × (syllabes / mots) ; 9 des phrases plus courtes et des mots plus courts font monter L.
2. Texte A : 84 / 4 = 21 mots par phrase ; 150 / 84 = 1,786 syllabe par mot ; L = 207 − 1,015 × 21 − 73,6 × 1,786 = 207 − 21,32 − 131,43 = 54,26 (calcul fait avec 150 / 84 non arrondi). Texte B : 60 / 8 = 7,5 ; 84 / 60 = 1,400 ; L = 207 − 7,61 − 103,04 = 96,35. Texte C : 45 / 2 = 22,5 ; 90 / 45 = 2,000 ; L = 207 − 22,84 − 147,2 = 36,96.
3. A : assez difficile (50-60) ; B : très facile (90-100) ; C : difficile (30-50). On choisit le texte B.
4. L'indice ne dépend pas de la longueur totale du texte mais de la longueur des phrases et des mots. Le texte C a de longues phrases (22,5 mots) et des mots longs (2 syllabes en moyenne).

Corrigé – Exercice 5.21

1. a) mots difficiles (« privilégier », « légumineuses »), forme impersonnelle ; b) phrase négative, sigles ; c) sigles, mots techniques ; d) chiffre abstrait (400 g), sigle ; e) phrase très longue avec plusieurs idées, forme impersonnelle ; f) majuscules, difficiles à lire ; g) tournure négative, mot technique ; h) mots difficiles, comparaison sans repère.
2. Exemples : a) « Mangez des lentilles, des pois chiches ou des haricots secs deux fois par semaine. » b) « Avant d'acheter, regardez la date sur l'emballage. » c) « Utilisez de l'huile de colza. Elle est bonne pour le cœur. » d) « Mangez 5 fruits et légumes par jour. Une portion, c'est la taille d'un poing. » e) « Ne jetez pas les restes. Faites une soupe ou un gratin. Vous ferez des économies. » f) « Les fruits et légumes de saison sont moins chers. » g) « Cuisinez des produits simples : légumes, œufs, pâtes, riz. » h) « Le pain complet contient plus de fibres. Il cale plus longtemps. » (Pour b), on peut ajouter une explication courte : « "À consommer jusqu'au" : ne pas dépasser. »)

Corrigé – Exercice 5.22

1. Première version : 186 / 6 = 31,0 mots par phrase ; 320 / 186 = 1,7204 syllabe par mot ; L = 207 − 1,015 × 31 − 73,6 × 1,7204 = 207 − 31,47 − 126,62 = 48,91, texte difficile. Version réécrite : 98 / 11 = 8,909 mots par phrase ; 147 / 98 = 1,5 ; L = 207 − 9,04 − 110,4 = 87,56, texte facile. Gain : 87,56 − 48,91 = 38,65 points.
2. Première version : 5 / 12 × 100 = 41,7 % ; version réécrite : 11 / 12 × 100 = 91,7 %.
3. Une seule phrase très longue ; vocabulaire administratif (« dans le cadre de », « nous sollicitons votre collaboration ») ; mots techniques (« diversification des collations », « produits céréaliers », « biscuiterie industrielle ») ; aucun exemple concret de goûter ; formulation négative (« au détriment de »).
4. Exemple : titre « Le goûter de l'après-midi ». « Votre enfant a faim à 16 h. » « Donnez-lui un fruit ou du pain. » « Ajoutez un yaourt ou un morceau de fromage. » « Pour boire, de l'eau suffit. »

5. L'indice montre seulement que les phrases et les mots sont plus courts. Le test montre que les parents ont réellement compris le message : 91,7 % au lieu de 41,7 %. C'est le test qui prouve la compréhension.

Corrigé – Exercice 5.23

1. Le FALC (Facile à lire et à comprendre) est une méthode d'écriture qui vient des règles européennes d'Inclusion Europe (2009). Elle a été conçue avec et pour les personnes en situation de handicap intellectuel.

2. Mots inconnus ou recherchés (« velouté Du Barry », « émincé », « sauce suprême », « beurre blanc », « pilaf ») ; sigle (AOP) ; tout est sur une ligne, sans séparation ni image ; majuscules au milieu des phrases ; choix multiples difficiles à repérer (« ou », « / ») ; allergènes non indiqués.

3. Exemple : titre « Jeudi » avec la photo du jour ; une ligne par plat, avec une photo de chaque plat : « Soupe de chou-fleur » ; « Plat : poulet en sauce blanche OU poisson en sauce » (deux photos côte à côte, le mot « OU » en gras) ; « Avec : riz ou légumes » ; « Fromage ou yaourt » ; « Dessert : gâteau aux pommes ». Pictogrammes des allergènes à côté de chaque plat (lait, poisson, gluten). Police sans empattement, grande taille, texte aligné à gauche, mêmes mots chaque jour pour les mêmes choses.

4. Des travailleurs de l'ESAT relisent le menu et disent ce qu'ils ne comprennent pas ; on corrige avec eux. C'est une règle du FALC : un document n'est « facile à lire » que si des personnes concernées l'ont validé. On peut alors utiliser le logo européen « Facile à lire ».

5. Ressource : SantéBD, bandes dessinées en FALC sur la santé. Autres publics : personnes qui apprennent le français, personnes âgées, personnes fatiguées ou qui lisent peu.

Corrigé – Exercice 5.24

1. Fiche 1 : L = 207 − 1,015 × (60 / 6) − 73,6 × (90 / 60) = 207 − 10,15 − 110,4 = 86,45. Fiche 2 : mêmes comptages, donc L = 86,45. Fiche 3 : 207 − 1,015 × 24 − 73,6 × 1,597 = 207 − 24,36 − 117,56 = 65,08.

2. Fiche 1 : 9 / 10 = 90 % ; fiche 2 : 3 / 10 = 30 % ; fiche 3 : 8 / 10 = 80 %.

3. L'indice ne compte que les mots, les phrases et les syllabes. La fiche 2 utilise des sigles courts mais incompréhensibles (IG, AGS, GL, T150) et des mots familiers sans sens précis (« OK ») : ils ne font pas baisser l'indice mais empêchent de comprendre. L'indice ne mesure pas le sens.

4. Ses phrases sont plus longues, mais la mise en page est aérée et les cinq photos montrent ce qu'il faut manger. L'indice ne tient compte ni de la mise en page ni des images.

5. Exemple : « L'indice est un bon outil pour repérer les phrases trop longues et les mots trop compliqués, et pour comparer deux versions d'un même texte. Mais il ne dit pas si le texte a du sens pour le public, s'il contient des sigles ou si la mise en page aide. Il faut donc toujours vérifier l'absence de sigles et de jargon, puis tester la fiche auprès de quelques personnes du public avant de la diffuser. »

Partie 5 – Vérifier la compréhension et animer un atelier accessible

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire la boucle du « faire dire » (teach-back) et ses cinq temps.
- Transformer une question fermée en question de « faire dire ».
- Construire une séquence d'atelier de 2 heures selon les précautions universelles.
- Calculer des taux de réussite à partir d'une grille d'observation et en tirer un ajustement.
- Adapter un message oral (message vocal, annonce).

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Boucle du « faire dire » : expliquer, faire dire, vérifier, réexpliquer autrement si besoin, confirmer.
- On présente la demande comme une vérification de sa propre clarté : « Pour être sûre d'avoir bien expliqué… »
- « Vous avez compris ? » appelle presque toujours « oui » : on préfère une question ouverte qui demande d'agir (« Montrez-moi comment vous choisiriez… »).
- La HAS a publié en 2015 une fiche-outil « Faire dire » ; la technique s'utilise aussi en groupe.
- Atelier accessible : accueil individuel, recueil des pratiques sans écrit (photolangage), un seul message, démonstration, pratique en binômes, dégustation, faire dire, support à emporter en photos.

Exercice 5.25 – Légender la boucle du « faire dire » (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 12 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous formez les animateurs d'un réseau de centres sociaux à la vérification de la compréhension. Vous partez du schéma de la boucle du « faire dire ».

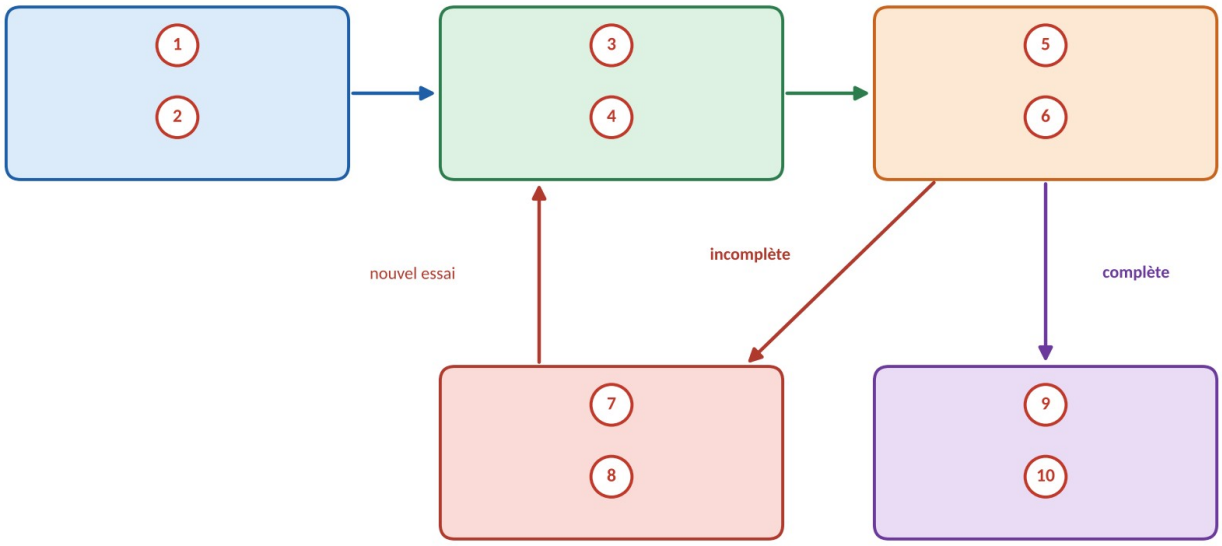


Figure 5.7 – Document 1 – La boucle du « faire dire » (schéma à légender)

Document 2 – Un échange observé en fin d'atelier

Animatrice : « Bon, les lentilles, c'est 20 minutes. Vous avez compris ? »

Participant : « Oui, oui. »

Animatrice : « Parfait, on range. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (5 pts)
2. Relevez deux erreurs de l'animatrice dans le document 2. (2 pts)
3. Réécrivez l'échange en suivant la boucle du « faire dire », avec une réponse incomplète du participant puis une nouvelle explication. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.26 – Des questions qui font agir (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous relisez avec une collègue le déroulé d'un atelier « petit-déjeuner » pour des parents dans un centre de protection maternelle et infantile (PMI). Chaque séquence se termine par une question fermée.

Document 1 – Les questions prévues

a) « Vous avez compris la différence entre les deux céréales ? »

b) « C'est clair pour la quantité de lait ? »

c) « Vous savez lire le Nutri-Score maintenant ? »

d) « Vous voyez combien de sucre il y a dans ce jus ? »

e) « Vous retiendrez de donner de l'eau ? »

f) « Des questions ? »

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi ces questions ne vérifient pas la compréhension. (2 pts)

2. Réécrivez chaque question en question de « faire dire » ou en consigne d'action. (6 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.27 – Analyser un « faire dire » en entretien (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre d'une action de prévention de la déshydratation l'été, le CCAS d'une ville (fictive) organise des visites à domicile. Vous accompagnez une conseillère auprès de Mme P., 84 ans, qui vit seule. Voici l'échange.

Document 1 – L'échange

Conseillère : « Quand il fait chaud, le corps perd de l'eau. Il faut boire même sans soif. Ce verre-là, c'est votre verre : il en faut 6 à 8 par jour. »

Conseillère : « Pour être sûre d'avoir été claire, vous pouvez me dire comment vous allez faire demain ? »

Mme P. : « Je bois quand j'ai soif, comme d'habitude. »

Conseillère : « Je vais le dire autrement. On va poser une bouteille ici, sur la table. Chaque fois que vous mangez ou que vous prenez vos médicaments, vous buvez un verre. Le soir, la bouteille doit être presque vide. »

Conseillère : « Vous pouvez me redire ce que vous allez faire avec cette bouteille ? »

Mme P. : « Un verre aux repas et avec les cachets. Et le soir je regarde la bouteille. »

Conseillère : « C'est exactement ça. Je vous laisse cette feuille avec le dessin de la bouteille et des verres. »

À vous de jouer – Questions

1. Repérez dans l'échange chacune des étapes de la boucle du « faire dire ». (5 pts)
2. Expliquez pourquoi la conseillère n'a pas répété sa première phrase, et ce qu'elle a changé. (3 pts)
3. Relevez deux autres adaptations utiles pour une personne âgée. (2 pts)
4. Proposez un moyen de vérifier, lors de la visite suivante, que le conseil est appliqué. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.28 – Construire une séquence d'atelier accessible (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – production · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mission locale (fictive) accompagne des jeunes de 16 à 25 ans dans le contrat d'engagement jeune (dispositif national créé en 2022). Elle vous demande un atelier de 2 heures « Manger bien avec 5 € par jour » pour 10 jeunes. La conseillère vous prévient : plusieurs jeunes ont quitté l'école tôt, trois parlent peu le français, presque tous ont un smartphone, et beaucoup « détestent les cours ».

Document 1 – Ressources disponibles

Une cuisine pédagogique avec deux plaques de cuisson ; un budget de courses de 25 € ; un vidéoprojecteur ; une médiatrice qui parle arabe et tigrigna, disponible 1 heure.

À vous de jouer – Questions

1. Formulez le message principal de l'atelier et un objectif de compétence. (2 pts)
2. Construisez la séquence de 120 minutes sous forme de tableau : durée, étape, ce que font les jeunes, adaptation de littératie. Vérifiez que le total fait 120 minutes. (6 pts)
3. Expliquez comment vous utilisez la médiatrice pendant l'heure où elle est présente. (2 pts)
4. Proposez un support à emporter adapté à ce public. (2 pts)
5. Dites comment vous organisez les binômes et pourquoi. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.29 – Exploiter une grille de « faire dire » (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

À la fin d'un atelier « cuisiner les légumes secs » dans une association de quartier (fictive), l'animatrice a noté pour chacun des 12 participants s'il a réussi quatre « faire dire ». Vous l'aidez à analyser la grille.

Document 1 – Grille d'observation (1 = réussi, 0 = non réussi, données fictives)

Participant	Item 1 : rincer et cuire les lentilles	Item 2 : dire une recette à refaire	Item 3 : estimer le prix d'une portion	Item 4 : citer deux légumes secs
A	1	1	0	1
B	1	1	1	1
C	1	0	0	1
D	1	1	1	0
E	1	1	0	1
F	0	1	0	0
G	1	1	1	1
H	1	0	1	1
I	1	1	0	0
J	1	1	0	1
K	1	1	1	1
L	1	0	0	0

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre et le taux de réussite de chaque item. (3 pts)
2. Calculez le taux de réussite global sur l'ensemble des 48 « faire dire ». (1 pt)
3. Calculez le nombre d'items réussis par chaque participant et repérez ceux qui en réussissent deux ou moins. (2 pts)
4. Identifiez l'item le moins réussi, nommez la compétence en jeu et proposez deux ajustements pour la séance suivante. (3 pts)
5. Expliquez ce que l'animatrice peut faire pour les participants F et L, sans les mettre en difficulté devant le groupe. (2 pts)
6. Pourquoi cette grille ne doit-elle pas être montrée aux participants comme une note ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.30 – Un message vocal pour rappeler l'atelier (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – production · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre social où vous êtes en stage envoie la veille de chaque atelier un message vocal sur WhatsApp aux participants. La référente familles vous demande d'écrire le texte du prochain message. Pour être bien compris, il ne doit pas durer plus de 45 secondes ; on retient dans cet exercice un débit lent de 120 mots par minute.

Document 1 – Informations à transmettre

Atelier « soupes d'hiver », mardi 12 janvier, de 14 h à 16 h, salle du rez-de-chaussée ; apporter un tablier et une boîte pour repartir avec de la soupe ; les enfants de moins de 3 ans peuvent venir ; c'est gratuit ; prévenir Samia au 06 00 00 00 00 (numéro fictif) en cas d'absence.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre maximal de mots du message. (1 pt)
2. Rédigez le message vocal en respectant cette limite. Indiquez le nombre de mots. (5 pts)
3. Citez trois règles de l'oral que vous avez appliquées. (2 pts)
4. Proposez une solution pour les participants qui n'ont pas WhatsApp. (1 pt)
5. Pourquoi est-il utile que le message soit enregistré par une personne connue des participants ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 5.25

1. Légendes : 1 Expliquer ; 2 un message à la fois, mots simples, support visuel ; 3 Faire dire ; 4 « Pour être sûre d'avoir été claire, que ferez-vous demain ? » ; 5 Vérifier ; 6 la reformulation est-elle complète et juste ? ; 7 Réexpliquer autrement ; 8 autre formulation, démonstration, image ; 9 Confirmer ; 10 valoriser, laisser un support.
2. Elle pose une question fermée (« Vous avez compris ? ») qui appelle un « oui » de politesse ; elle ne demande pas au participant de reformuler ou de montrer ; elle conclut sans rien vérifier ; son message est flou (« 20 minutes » de quoi ? pour quelles lentilles ?).
3. Exemple : Animatrice : « Les lentilles corail, on les rince, puis on les cuit 20 minutes dans deux fois leur volume d'eau. Pour être sûre d'avoir été claire, vous pouvez me dire comment vous allez les préparer chez vous ? » Participant : « Je les mets dans l'eau 20 minutes. » Animatrice : « Je vous montre encore une fois : d'abord, on les rince sous l'eau froide, comme ça. Ensuite, un verre de lentilles et deux verres d'eau. Vous me montrez ? » Participant : « Je rince, puis un verre de lentilles, deux verres d'eau, et 20 minutes. » Animatrice : « Exactement. Voilà la fiche en photos pour la maison. »

Corrigé – Exercice 5.26

1. Ce sont des questions fermées : la personne répond « oui » par politesse, par gêne ou pour ne pas paraître en difficulté. Elles ne demandent ni de reformuler ni d'agir, donc elles ne montrent pas ce qui a été compris.
2. Exemples : a) « Voici deux paquets de céréales. Montrez-moi celui que vous choisiriez pour le matin, et dites pourquoi. » b) « Avec ce verre doseur, montrez-moi la quantité de lait pour le bol de votre enfant. » c) « Votre voisine hésite entre ces deux biscuits : expliquez-lui comment le Nutri-Score l'aide à choisir. » d) « Posez à côté du jus le nombre de morceaux de sucre qu'il contient. » e) « Demain, au goûter, qu'est-ce que vous allez donner à boire ? » f) « Qu'est-ce que vous allez essayer cette semaine à la maison ? »

Corrigé – Exercice 5.27

1. Expliquer : « Quand il fait chaud, le corps perd de l'eau… 6 à 8 par jour. » Faire dire : « Pour être sûre d'avoir été claire, vous pouvez me dire comment vous allez faire demain ? » Vérifier : la réponse « Je bois quand j'ai soif » montre que le message n'est pas passé. Réexpliquer autrement : « Je vais le dire autrement. On va poser une bouteille ici… » Confirmer : nouvelle reformulation de Mme P., puis « C'est exactement ça » et remise de la feuille.
2. Répéter la même phrase n'aurait rien changé : c'est la manière d'expliquer qui ne convenait pas. La conseillère est passée d'un chiffre abstrait (6 à 8 verres) à un repère concret et visible (une bouteille sur la table), relié à des habitudes existantes (les repas, les médicaments) et à une vérification simple (la bouteille presque vide le soir).
3. Elle explique pourquoi il faut boire sans soif (la soif diminue avec l'âge) ; elle montre l'objet réel (le verre) ; elle laisse un support en dessin, sans texte long ; elle valorise la réponse.
4. Exemples : regarder avec Mme P. la bouteille du jour ; lui demander de raconter sa journée d'hier et quand elle a bu ; demander à l'aide à domicile si la bouteille est vide le soir.

Corrigé – Exercice 5.28

1. Message principal : « Avec 5 € par jour, on peut manger bien et à sa faim en cuisinant des produits simples. » Objectif : à la fin de l'atelier, chaque jeune sait préparer un plat complet pour moins de 1,50 € la portion.
2. Exemple de séquence : 10 min, accueil : prénoms, café, consignes de sécurité montrées en pictogrammes ; 10 min, recueil des pratiques : chacun montre sur son téléphone la photo d'un repas de la semaine ou

choisit une photo sur la table, sans rien écrire ; 15 min, message principal : comparaison de prix avec des objets réels (paquet de pâtes, boîte de pois chiches, plat préparé, sandwich acheté), prix par portion écrits en gros ; 10 min, démonstration d'une recette (pâtes aux pois chiches et à la tomate) montrée lentement ; 40 min, cuisine en binômes avec la recette en photos, une action par photo ; 15 min, repas partagé et dégustation avec une échelle à smileys ; 15 min, faire dire : chaque binôme montre une astuce et dit le prix de son assiette ; 5 min, clôture : remise du support, date suivante. Total : 10 + 10 + 15 + 10 + 40 + 15 + 15 + 5 = 120 minutes.

3. On la fait venir pendant la première heure : elle traduit l'accueil, les consignes de sécurité et le message principal ; elle reste avec le binôme qui en a le plus besoin pendant la démonstration et le début de la pratique. Les consignes importantes sont aussi données par gestes et en images.

4. Exemple : une courte vidéo sous-titrée de la recette, envoyée sur le téléphone, plus une carte recette en photos avec le prix de chaque ingrédient ; ces jeunes utilisent beaucoup leur smartphone, et la vidéo ne demande pas de lire.

5. On forme des binômes mixtes : un jeune qui lit facilement avec un jeune qui lit moins, ou un jeune qui parle peu le français avec un jeune de la même langue s'il y en a. L'entraide permet à chacun de réussir sans être désigné, et favorise les échanges.

Corrigé – Exercice 5.29

1. Item 1 : 11 / 12 = 91,7 % ; item 2 : 9 / 12 = 75,0 % ; item 3 : 5 / 12 = 41,7 % ; item 4 : 8 / 12 = 66,7 %.

2. (11 + 9 + 5 + 8) / 48 = 33 / 48 × 100 = 68,8 %.

3. Items réussis : A 3 ; B 4 ; C 2 ; D 3 ; E 3 ; F 1 ; G 4 ; H 3 ; I 2 ; J 3 ; K 4 ; L 1. Deux ou moins : C, F, I et L.

4. L'item 3, estimer le prix d'une portion (41,7 %), est le moins réussi : c'est une compétence de numératie. Ajustements : afficher le prix de chaque ingrédient par portion, déjà calculé, sur des étiquettes ; faire un exercice en binôme de comparaison de deux assiettes avec des pièces de monnaie réelles ; utiliser des chiffres ronds (« 20 centimes »).

5. Elle peut se placer à côté d'eux pendant la prochaine pratique, leur confier un rôle qu'ils maîtrisent, refaire la démonstration pour tout le groupe ou leur proposer de former un binôme avec un participant à l'aise. Elle ne cite jamais leurs résultats devant le groupe.

6. La grille sert à évaluer l'atelier et à ajuster l'animation, pas à juger les personnes. Une note mettrait certains participants en échec et pourrait les faire partir.

Corrigé – Exercice 5.30

1. 120 × 45 / 60 = 90 mots au plus.

2. Exemple (81 mots, en comptant chaque groupe de deux chiffres du numéro comme un mot) : « Bonjour, c'est Samia, du centre social. Demain, mardi 12 janvier, on fait des soupes d'hiver ensemble. C'est de 14 heures à 16 heures. C'est dans la salle du rez-de-chaussée. Apportez un tablier. Apportez aussi une boîte : vous repartirez avec de la soupe. Vos enfants de moins de 3 ans peuvent venir. C'est gratuit. Si vous ne pouvez pas venir, appelez-moi, Samia, au 06 00 00 00 00. Je répète : demain mardi, 14 heures, avec un tablier et une boîte. À demain ! »

3. Phrases courtes, une information par phrase ; mots courants ; répétition des informations clés à la fin (jour, heure, matériel) ; débit lent ; prénom de la personne qui parle.

4. Un appel téléphonique la veille ou un SMS court, et une carte papier remise à l'atelier précédent avec la date et un dessin.

5. Une voix connue inspire confiance, le message est écouté et l'on sait qui appeler. Cela renforce le lien entre le centre et les familles.

Partie 6 – Lire une étiquette et comprendre les chiffres : littératie alimentaire et numératie

Objectifs – Objectifs de la partie

- Repérer les six informations clés d'une étiquette (règlement (UE) n° 1169/2011, dit « INCO »).
- Lire une liste d'ingrédients : ordre, allergènes, part de l'ingrédient mis en avant.
- Convertir des sucres en morceaux et les situer par rapport au repère de l'OMS.
- Passer des valeurs « pour 100 g » aux valeurs « par portion » et calculer un coût par portion.
- Présenter un risque en fréquences naturelles, avec la réduction absolue et la réduction relative.
- Traduire un repère chiffré en aliments et en mesures concrètes.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Règlement INCO (2011) : dénomination, liste des ingrédients par ordre décroissant de poids, 14 allergènes mis en évidence, quantité nette, dates, conservation, déclaration nutritionnelle pour 100 g ou 100 mL.
- DLC « à consommer jusqu'au » : ne pas dépasser. DDM « à consommer de préférence avant » : le produit reste consommable après, s'il est bien conservé.
- Nutri-Score : comparer des produits d'une même famille.
- Un morceau de sucre pèse environ 5 g. OMS : sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique ; 50 g pour 2 000 kcal ; 42,5 g pour 1 700 kcal (enfant de 8 ans environ).
- Fréquences naturelles (« 6 personnes sur 100 ») ; réduction absolue = différence des risques ; réduction relative = différence / risque de départ. Présenter toujours les deux.
- Fibres : 30 g par jour chez l'adulte (ANSES, 2016).

Exercice 5.31 – Légender une étiquette (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 12 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un atelier « lire une étiquette » pour des adhérents d'une association de locataires. Vous commencez par un schéma d'emballage à compléter ensemble.

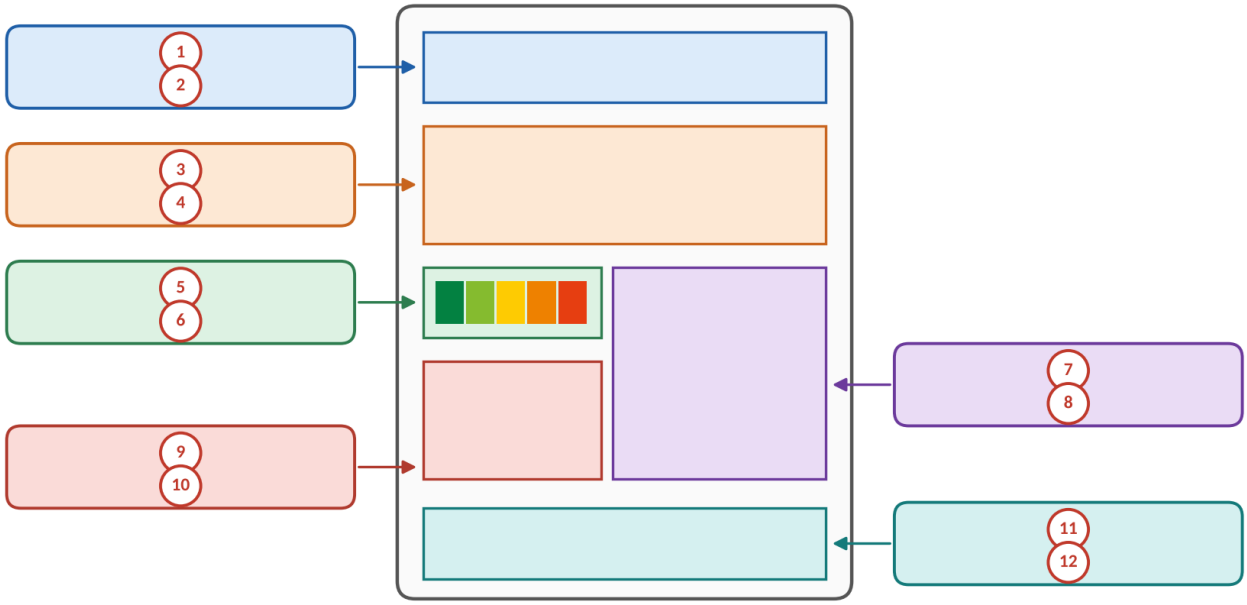


Figure 5.8 – Document 1 – Lire une étiquette (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (6 pts)
2. Citez le texte européen qui rend la plupart de ces informations obligatoires et l'année de son adoption. (1 pt)
3. Lequel de ces éléments est facultatif sur l'emballage ? Lequel n'est pas sur l'emballage mais sur l'étiquette du rayon ? (1 pt)
4. Expliquez la différence entre DLC et DDM avec un exemple d'aliment pour chacune. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.32 – Lire trois listes d'ingrédients (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pendant l'atelier, une adhérente vous montre trois produits de son placard. Elle pensait que le premier contenait des fraises.

Document 1 – Les étiquettes (produits fictifs)

- Produit 1, « Yaourt aromatisé saveur fraise » : lait écrémé, sucre, crème, amidon modifié de maïs, arôme, colorant : carmins, ferments lactiques.
- Produit 2, « Yaourt aux fruits, fraise » : lait entier, préparation de fraise 15 % (fraise 10 %, sucre, eau, épaississant : pectines), sucre, ferments lactiques.
- Produit 3, « Céréales croustillantes au chocolat » : farine de blé, sucre, farine de riz, cacao maigre en poudre 6 %, huile de tournesol, sirop de glucose, sel, émulsifiant : lécithines de soja, arôme.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez, à partir de la dénomination et de la liste, pourquoi le produit 1 ne contient pas de fraise. (2 pts)

2. Calculez la quantité de fraise dans un pot de 125 g du produit 2. (1 pt)

3. Pour chaque produit, citez le premier ingrédient et ce qu'il indique. (1,5 pt)

4. Relevez les allergènes réglementaires des trois produits. Comment doivent-ils apparaître sur l'emballage ? (2 pts)

5. Dans le produit 3, relevez les ingrédients qui apportent des sucres et dites ce que vous concluez de leur place. (2 pts)

6. Rédigez en écriture claire le conseil que vous donnez à l'adhérente. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.33 – Les boissons en morceaux de sucre (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et interprétation · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un atelier avec des parents d'élèves d'un collège, vous voulez poser à côté de chaque boisson le nombre de morceaux de sucre qu'elle contient. Vous utilisez les valeurs de la table Ciqual 2025.

Document 1 – Teneur en sucres (Ciqual 2025, pour 100 g, assimilés à 100 mL)

Boisson (code Ciqual)	Sucres (g pour 100 g)	Énergie (kcal pour 100 g)	Contenant présenté
Boisson gazeuse aromatisée, sans fruit, sucrée (18026)	8,28	34,5	canette de 33 cL
Jus d'orange, pur jus (2070)	9,61	45,4	verre de 20 cL
Boisson au thé, aromatisée, sucrée (18075)	5,65	23,2	bouteille de 50 cL
Nectar multifruit, base pomme, standard (2009)	10	41,1	brique de 20 cL

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque contenant, la quantité de sucres (au dixième de gramme) et le nombre de morceaux de sucre de 5 g (au dixième). (4 pts)
2. Calculez, pour chaque contenant, la part du repère de l'OMS pour un adulte à 2 000 kcal (50 g) et pour un enfant à 1 700 kcal (42,5 g). (3 pts)
3. Un parent dit : « Le thé glacé, c'est léger, il y a moins de sucre que dans le soda. » Répondez-lui avec les chiffres. (2 pts)
4. Le pur jus d'orange ne contient pas de sucre ajouté. Expliquez pourquoi on le compte quand même. (1 pt)
5. Expliquez pourquoi on montre des morceaux de sucre plutôt que des grammes. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.34 – Pour 100 g ou par portion ? Deux goûters comparés (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et interprétation · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une animatrice d'accueil de loisirs hésite entre deux biscuits pour les goûters des 8-10 ans. Elle vous montre les étiquettes et les prix relevés au magasin.

Document 1 – Extraits des étiquettes (produits fictifs)

Pour 100 g	Biscuit A, galette à l'avoine	Biscuit B, biscuit fourré chocolat
Énergie	450 kcal	480 kcal
Sucres	18 g	35 g
Fibres	7 g	3 g
Sel	0,6 g	0,5 g
Portion indiquée	2 galettes = 25 g	1 sachet = 38 g
Prix au kilo	3,40 €	6,20 €
Nutri-Score	B	E

À vous de jouer – Questions

1. Calculez pour une portion de chaque biscuit : l'énergie, les sucres (et en morceaux), les fibres et le sel. (4 pts)
2. Calculez le coût d'une portion de chaque biscuit (au centime). (2 pts)
3. Le biscuit A a presque autant de calories pour 100 g que le biscuit B. Expliquez pourquoi la comparaison par portion change la conclusion, et la limite de cette comparaison. (2 pts)
4. Proposez à l'animatrice un goûter complet à partir du biscuit A. (2 pts)
5. Rédigez le message clé de l'atelier en une phrase « mieux et moins cher ». (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.35 – Présenter honnêtement un risque (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et argumentation · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un atelier « démêler le vrai du faux » avec des étudiants en formation d'aide-soignant. Vous partez d'un tableau d'icônes, puis de trois slogans relevés dans des publicités et des articles.

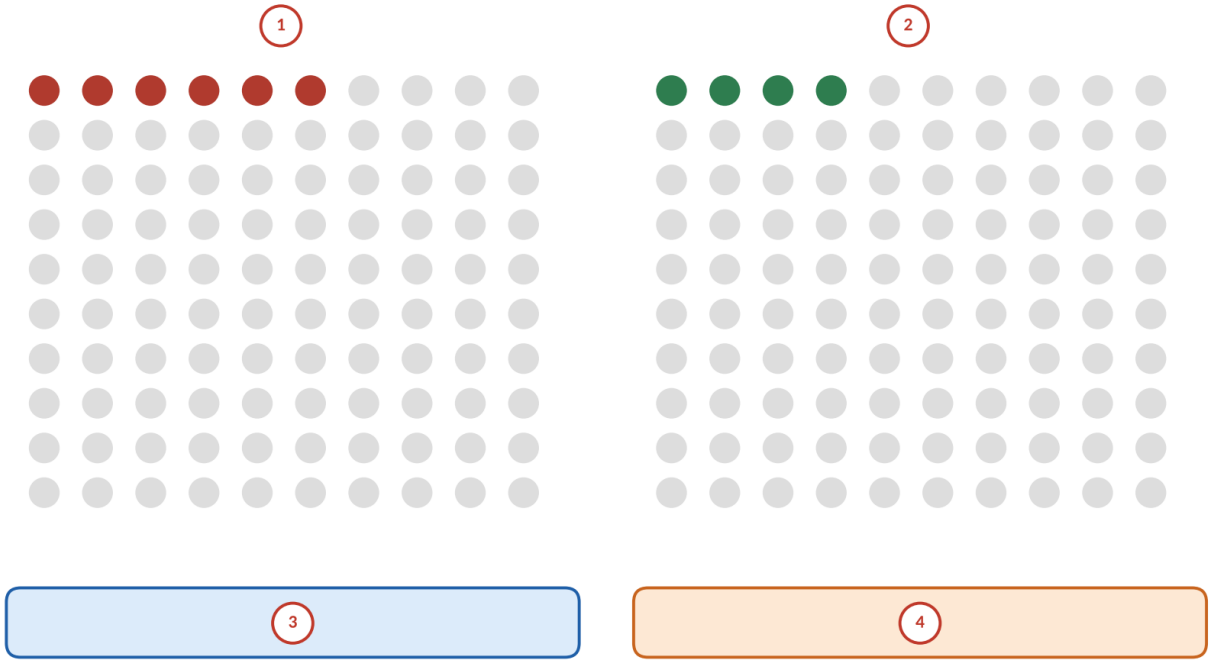


Figure 5.9 – Document 1 – Un risque présenté en fréquences naturelles (schéma à légender)

Document 2 – Trois slogans et les résultats des études citées (données fictives)

a) « Cette margarine réduit de 20 % le risque cardiaque ! » Étude : 10 personnes sur 1 000 ont un accident cardiaque sans la margarine, 8 sur 1 000 avec.

b) « Ce programme de marche réduit de 20 % le risque de chute ! » Étude : 15 personnes sur 100 chutent sans le programme, 12 sur 100 avec.

c) « Les ateliers cuisine réduisent d'un tiers le grignotage ! » Étude : 30 personnes sur 100 grignotent chaque jour sans atelier, 20 sur 100 avec.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Pour chaque slogan, calculez la réduction absolue et la réduction relative. (3 pts)
3. Les slogans a) et b) annoncent la même réduction relative. Expliquez pourquoi leur intérêt réel est très différent. (2 pts)
4. Réécrivez le slogan a) en fréquences naturelles, de façon honnête. (2 pts)
5. Décrivez le tableau d'icônes que vous dessineriez pour le slogan b). (1 pt)
6. Citez deux questions à poser sur l'étude avant de croire un slogan. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.36 – Traduire les repères chiffrés en assiettes (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un club de prévention santé (fictif) pour des adultes en surpoids, plusieurs participants disent : « 30 g de fibres par jour, je ne sais pas ce que ça veut dire. » Vous voulez leur montrer une journée simple qui atteint ce repère, puis traduire les chiffres en mesures concrètes.

Document 1 – Une journée proposée (Ciqual 2025, fibres en g pour 100 g)

Aliment (code Ciqual)	Quantité	Fibres pour 100 g
Pain complet ou intégral, farine T150 (7110)	60 g	7,3
Riz complet, cuit (9103)	150 g	2,1
Lentille verte, cuite à l'eau (20587)	150 g	8,45
Carotte, crue (20009)	100 g	2,9
Pomme, chair et peau, crue (13039)	150 g	1,4
Haricot vert, cuit à l'eau (20320)	150 g	3,2
Orange, crue (13034)	150 g	2,7

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'apport en fibres de chaque aliment (au centième) et le total de la journée. (4 pts)
2. Calculez la part du repère de 30 g couverte par cette journée et l'aliment qui apporte le plus de fibres. (2 pts)
3. Traduisez chaque quantité du document 1 en une mesure concrète utilisable sans balance. (3 pts)
4. Réécrivez le repère « 30 g de fibres par jour » en trois conseils concrets, sans chiffre en grammes. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi il faut augmenter les fibres progressivement et boire en même temps. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 5.31

1. Légendes : 1 Dénomination ; 2 ce qu'est vraiment le produit ; 3 Liste d'ingrédients ; 4 ordre décroissant ; 14 allergènes en gras ; 5 Nutri-Score ; 6 comparer dans une même famille ; 7 Tableau nutritionnel ; 8 pour 100 g et par portion ; 9 Dates ; 10 DLC « jusqu'au » ; DDM « de préférence avant » ; 11 Prix au kilo ; 12 en rayon, pour comparer.
2. Le règlement (UE) n° 1169/2011, dit « INCO », adopté en 2011.
3. Le Nutri-Score est facultatif. Le prix au kilo est affiché sur l'étiquette du rayon.
4. DLC (« à consommer jusqu'au ») : produit très périssable, on ne le consomme pas après la date (viande hachée, yaourt, jambon). DDM (« à consommer de préférence avant ») : après la date, le produit peut perdre un peu de goût ou de qualité mais reste consommable s'il est bien conservé (pâtes, riz, biscuits, conserves).

Corrigé – Exercice 5.32

1. La dénomination dit « saveur fraise » : le goût vient de l'arôme et la couleur du colorant (carmins). Le mot « fraise » n'apparaît pas dans la liste des ingrédients.
2. 125 × 10 / 100 = 12,5 g de fraise par pot.
3. Produit 1 et produit 2 : le lait est le premier ingrédient, c'est bien un yaourt. Produit 3 : la farine de blé est le premier ingrédient ; le sucre arrive en deuxième position, ce qui montre qu'il y en a beaucoup.
4. Lait (produits 1 et 2 : lait, crème, ferments), céréales contenant du gluten (blé, produit 3) et soja (lécithines de soja, produit 3). Ils doivent être mis en évidence dans la liste, par exemple en gras ou soulignés.
5. Sucre (2e), sirop de glucose (6e) ; le cacao et la farine en apportent un peu. Le sucre est cité en deuxième position et il existe une deuxième source de sucres ajoutés : ce sont des céréales sucrées, à réserver à une consommation occasionnelle.
6. Exemple : « Lisez le nom du produit. "Saveur fraise" veut dire : pas de fraise. Prenez un yaourt nature et ajoutez des fraises ou une cuillère de confiture. »

Corrigé – Exercice 5.33

1. Soda : 8,28 × 330 / 100 = 27,3 g, soit 27,3 / 5 = 5,5 morceaux. Pur jus d'orange : 9,61 × 2 = 19,2 g, soit 3,8 morceaux. Thé glacé : 5,65 × 5 = 28,2 g, soit 5,7 morceaux. Nectar : 10 × 2 = 20,0 g, soit 4,0 morceaux.
2. Soda : 27,3 / 50 × 100 = 54,6 % (adulte), 27,3 / 42,5 × 100 = 64,3 % (enfant). Pur jus : 38,4 % et 45,2 %. Thé glacé : 56,5 % et 66,5 %. Nectar : 40,0 % et 47,1 %.
3. Pour 100 mL, le thé glacé contient en effet moins de sucres que le soda (5,65 g contre 8,28 g). Mais la bouteille de 50 cL en apporte 28,2 g, soit 5,7 morceaux, un peu plus que la canette de soda (5,5 morceaux). Ce qui compte, c'est ce que l'on boit réellement.
4. L'OMS compte parmi les sucres libres les sucres naturellement présents dans les jus de fruits. Le jus n'a pas les fibres du fruit et se boit vite ; on garde le repère d'un petit verre par jour au plus et l'on préfère le fruit entier.
5. Les grammes sont abstraits et difficiles à se représenter. Les morceaux de sucre sont des objets connus, visibles, que l'on peut poser à côté de la boisson : l'information est comprise sans calcul et marque les esprits. C'est une adaptation à la numératie du public.

Corrigé – Exercice 5.34

1. Biscuit A (25 g, soit 0,25 × les valeurs pour 100 g) : énergie 450 × 0,25 = 112,5 kcal ; sucres 18 × 0,25 = 4,5 g, soit 0,9 morceau ; fibres 1,75 g ; sel 0,15 g. Biscuit B (38 g, soit 0,38 ×) : énergie 480 × 0,38 = 182,4

kcal ; sucres 35 × 0,38 = 13,3 g, soit 2,7 morceaux ; fibres 1,14 g ; sel 0,19 g.

2. A : 25 / 1 000 × 3,40 = 0,085 €, soit 0,09 € (environ 9 centimes). B : 38 / 1 000 × 6,20 = 0,236 €, soit 0,24 €.

3. Pour 100 g, les deux biscuits sont proches en énergie. Mais la portion de B est plus grosse (38 g contre 25 g) : il apporte 70 kcal de plus et trois fois plus de sucres par portion. La limite : la portion indiquée par le fabricant n'est pas toujours celle que mangent les enfants ; il faut aussi regarder ce qui est réellement consommé.

4. Exemple : deux galettes à l'avoine, une pomme ou une clémentine, un verre de lait ou un yaourt nature, de l'eau à volonté.

5. Exemple : « La galette à l'avoine : moins de sucre, plus de fibres, et presque trois fois moins chère par goûter. »

Corrigé – Exercice 5.35

1. Légendes : 1 Sans action : 6 personnes sur 100 ; 2 Avec action : 4 personnes sur 100 ; 3 réduction absolue : 2 personnes sur 100 ; 4 réduction relative : (6 − 4) / 6 = 33 %.

2. a) Absolue : 10 − 8 = 2 personnes sur 1 000 ; relative : 2 / 10 × 100 = 20 %. b) Absolue : 15 − 12 = 3 personnes sur 100 ; relative : 3 / 15 × 100 = 20 %. c) Absolue : 30 − 20 = 10 personnes sur 100 ; relative : 10 / 30 = 33,3 %, soit un tiers.

3. Pour a), 2 personnes sur 1 000 sont protégées ; pour b), 3 personnes sur 100, soit 30 sur 1 000, quinze fois plus. La réduction relative est la même parce qu'elle ne tient pas compte du risque de départ, très faible en a). Annoncer seulement le relatif exagère l'effet perçu.

4. « Sur 1 000 personnes, 10 ont un accident cardiaque sans cette margarine et 8 avec : 2 personnes sur 1 000 évitent un accident. »

5. Deux grilles de 100 personnes : 15 icônes colorées dans la première, 12 dans la seconde ; les 3 icônes de différence sont entourées.

6. Qui a financé l'étude ? Combien de personnes ont été suivies et pendant combien de temps ? Les groupes étaient-ils comparables (tirage au sort) ? L'étude a-t-elle été publiée dans une revue scientifique ?

Corrigé – Exercice 5.36

1. Pain complet : 7,3 × 0,6 = 4,38 g ; riz complet : 2,1 × 1,5 = 3,15 g ; lentilles : 8,45 × 1,5 = 12,68 g ; carotte : 2,90 g ; pomme : 1,4 × 1,5 = 2,10 g ; haricots verts : 3,2 × 1,5 = 4,80 g ; orange : 2,7 × 1,5 = 4,05 g. Total : 34,05 g (calcul fait sur les valeurs non arrondies).

2. 34,05 / 30 × 100 = 113,5 % : le repère est dépassé. Les lentilles apportent le plus de fibres (12,68 g, plus d'un tiers du total).

3. Exemples : pain complet 60 g = deux tranches ou un quart de baguette ; riz complet cuit 150 g = environ un bol à moitié plein, ou 4 cuillères à soupe pleines ; lentilles cuites 150 g = environ trois quarts de bol ; carotte 100 g = une grosse carotte ; pomme 150 g = une pomme moyenne ; haricots verts 150 g = une grosse poignée cuite, le volume de deux poings ; orange 150 g = une orange moyenne. On vérifie ces repères en pesant une fois en atelier.

4. Exemples : « Prenez du pain complet ou des céréales complètes au petit-déjeuner. » « Mettez des légumes à chaque repas et des fruits au dessert. » « Mangez des lentilles, des pois chiches ou des haricots secs au moins deux fois par semaine. »

5. Une augmentation brutale des fibres peut donner des ballonnements et des douleurs du ventre, qui découragent. L'eau aide les fibres à jouer leur rôle sur le transit. On augmente donc peu à peu, sur deux ou trois semaines, en buvant régulièrement.

Partie 7 – Numérique, langues et handicaps : rendre l'information accessible

Objectifs – Objectifs de la partie

- Choisir une adaptation selon la situation : langue, numérique, déficience visuelle, auditive ou intellectuelle, lecture difficile.
- Évaluer une application ou un site d'information alimentaire avec une grille de critères.
- Réaliser un mini-audit d'accessibilité et calculer un ratio de contraste.
- Choisir la bonne ressource pour communiquer avec une personne allophone.
- Construire un plan de communication qui n'exclut pas les personnes éloignées du numérique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Allophone : personne dont la langue maternelle n'est pas celle du pays où elle vit.
- Interprétariat professionnel pour les échanges importants ou sensibles (référentiel de la HAS, 2017) ; médiateurs en santé pour le lien de confiance ; éviter les enfants interprètes et les traducteurs automatiques non relus.
- Accessibilité numérique : RGAA, fondé sur les normes internationales WCAG ; contraste suffisant, texte alternatif des images, vidéos sous-titrées, liens explicites, navigation simple.
- Ratio de contraste = (L1 + 0,05) / (L2 + 0,05), L1 étant la luminance relative de la couleur la plus claire ; seuil de 4,5 pour un texte courant et de 3 pour un grand texte (WCAG, niveau AA).
- Ne jamais réserver une inscription ou une information au seul numérique (illectronisme : 7 % des 16-74 ans en 2025, Insee).

Exercice 5.37 – Une adaptation pour chaque situation (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 12 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison des solidarités (fictive) accueille un public très varié. L'équipe vous demande une affiche interne qui résume les adaptations possibles.

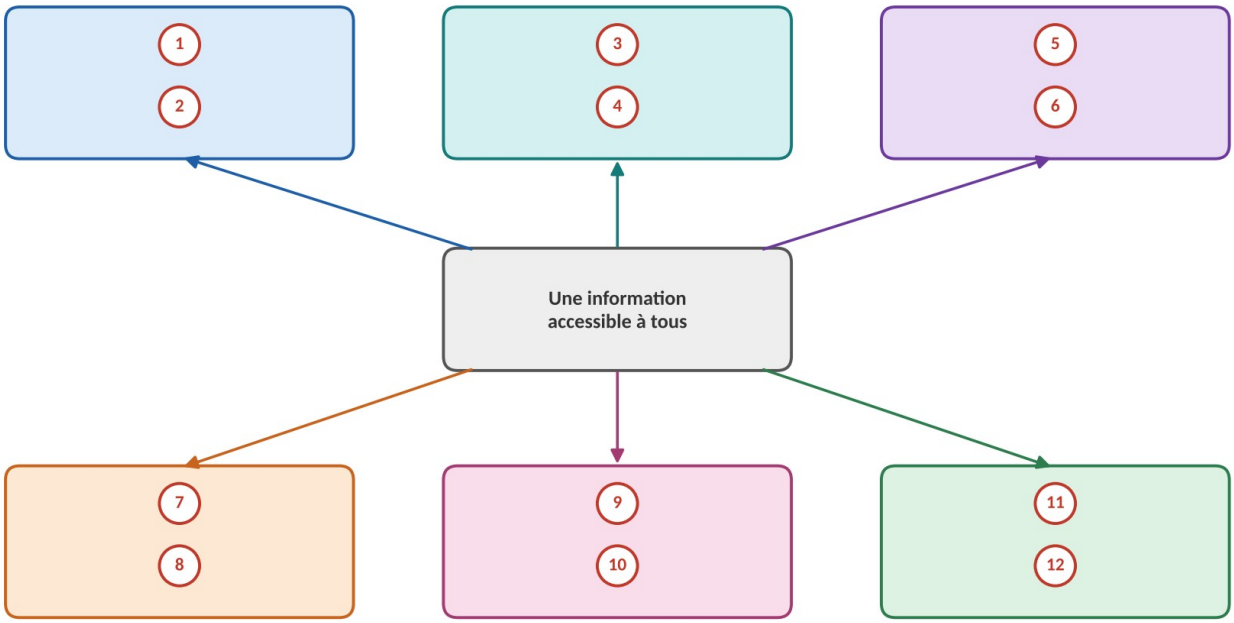


Figure 5.10 – Document 1 – Adapter selon la situation (schéma à légender)

Document 2 – Six personnes accueillies cette semaine

a) M. V., aveugle depuis l'enfance, utilise un lecteur d'écran.

b) Mme O., 38 ans, arrivée d'Ukraine, parle russe et ukrainien.

c) M. S., 24 ans, travailleur d'ESAT, vit en foyer.

d) Mme J., 67 ans, malentendante, lit très bien.

e) M. N., 52 ans, n'a pas d'ordinateur et ne sait pas envoyer un document par courriel.

f) Mme E., 45 ans, a quitté l'école à 14 ans et lit difficilement.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (6 pts)
2. Pour chaque personne du document 2, proposez l'adaptation la plus utile pour l'inviter à un atelier cuisine. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi une affiche avec un gros titre, des pictogrammes et une version audio profite à presque tout le monde. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.38 – Évaluer une application de scan (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Des participants d'un atelier vous demandent s'ils peuvent faire confiance à une application de scan des produits très populaire dans leur entourage. Vous l'analysez avec la grille du cours.

Document 1 – Ce que vous avez relevé sur l'application « ScanFood+ » (application fictive)

- Éditeur : une jeune entreprise ; l'application est gratuite, financée par des publicités pour des compléments alimentaires.
- Notes : une note sur 100 calculée par « notre algorithme exclusif », sans explication publique ; le Nutri-Score officiel n'est pas affiché.
- Mise à jour : la base de produits a été mise à jour il y a trois ans.
- Données : demande l'accès à la localisation et aux contacts ; la politique de confidentialité indique un partage avec des « partenaires commerciaux ».
- Accessibilité : textes en petits caractères gris clair, disponible seulement en français.
- Usage : affiche un message rouge « À ÉVITER ! » sur le pain, les bananes et le fromage ; propose de « compter chaque calorie ».

À vous de jouer – Questions

1. Notez l'application sur chacun des six critères de la grille du cours (éditeur et financement, fondement scientifique, mise à jour, protection des données, accessibilité, effets indésirables) avec 0 (insuffisant), 1 (moyen) ou 2 (satisfaisant), en justifiant. Calculez la note sur 12. (6 pts)

2. Rédigez trois conseils simples pour les participants qui utilisent une application de scan. (3 pts)

3. Citez un site public fiable sur l'alimentation à leur présenter. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.39 – Rendre accessible la page d'inscription (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre communal d'action sociale (fictif) a créé une page internet pour présenter ses ateliers « cuisine et santé » et s'inscrire. Vous faites un mini-audit avec 15 critères simples, puis vous vérifiez les couleurs.

Document 1 – Résultat du mini-audit

Critères respectés (6) : langue de la page déclarée ; titres structurés ; police agrandissable ; adresse postale affichée ; pas de limite de temps pour remplir le formulaire ; version imprimable du programme.

Critères non respectés (9) : contraste du texte ; texte alternatif des 5 photos ; sous-titres de la vidéo de présentation ; liens explicites (« cliquez ici ») ; numéro de téléphone visible ; information donnée seulement par la couleur (« les ateliers en vert sont complets ») ; formulaire avec 14 champs obligatoires ; version en FALC ; possibilité de s'inscrire autrement qu'en ligne.

Document 2 – Couleurs de la page et luminances relatives (calculées selon les WCAG)

Élément	Texte	Fond	Luminance du texte	Luminance du fond
Texte courant	gris clair (#999999)	blanc (#FFFFFF)	0,3185	1,0000
Bouton « S'inscrire »	blanc (#FFFFFF)	orange (#F28C28)	1,0000	0,3779
Titre	bleu foncé (#1F3A93)	blanc (#FFFFFF)	0,0542	1,0000
Proposition pour le bouton	gris très foncé (#333333)	orange (#F28C28)	0,0331	0,3779

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de critères respectés. (1 pt)
2. Choisissez six corrections rapides et peu coûteuses, puis calculez le nouveau pourcentage. (3 pts)
3. Calculez le ratio de contraste de chaque ligne du document 2 (au centième) et dites s'il respecte le seuil de 4,5. (4 pts)
4. Proposez une correction pour le texte courant et justifiez le choix de la proposition pour le bouton. (2 pts)
5. Réécrivez le lien « cliquez ici » et l'information « les ateliers en vert sont complets ». (2 pts)
6. Expliquez pourquoi le critère « s'inscrire autrement qu'en ligne » est le plus important pour ce public. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.40 – Communiquer avec des parents allophones (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une crèche collective (fictive) d'un quartier prioritaire accueille 40 enfants ; 14 familles parlent peu le français. La directrice veut organiser une réunion sur la diversification alimentaire et sur les allergies. Elle propose plusieurs solutions.

Document 1 – Les solutions envisagées par la directrice

a) Demander aux grands frères et sœurs de traduire pour leurs parents.

b) Traduire le document de la crèche avec un traducteur automatique en ligne et l'imprimer tel quel.

c) Faire appel à un service d'interprétariat professionnel par téléphone pour les entretiens individuels sur les allergies.

d) Inviter une médiatrice en santé du quartier qui connaît bien les familles.

e) Montrer les aliments réels et les textures (purée lisse, écrasée, morceaux) pendant la réunion.

f) Proposer un atelier avec l'association d'apprentissage du français du quartier, autour de la préparation de purées.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque solution, dites si vous la retenez ou non et justifiez. (6 pts)
2. Expliquez pourquoi l'entretien sur les allergies demande un interprète professionnel et pas une médiatrice. (2 pts)
3. Proposez un moyen de vérifier, à la fin de la réunion, que les parents ont compris l'âge de début de la diversification. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.41 – Un atelier cuisine avec des personnes sourdes et malentendantes (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association (fictive) de personnes sourdes et malentendantes vous demande quatre ateliers de 2 h 30 sur les repas rapides et équilibrés. Le groupe compte 12 personnes : 7 personnes sourdes qui communiquent en langue des signes française (LSF), 5 personnes malentendantes appareillées qui lisent sur les lèvres.

Document 1 – Informations pratiques

- La pratique courante est de faire appel à deux interprètes en LSF qui se relaient pour une intervention de plus d'une heure.
- Tarif retenu pour l'exercice (tarif fictif) : 65 € de l'heure par interprète.
- Budget de l'association pour les quatre ateliers : 1 500 €, dont 200 € de courses.
- La cuisine est bruyante (hotte, robot) et éclairée par une seule fenêtre derrière le plan de travail de l'animatrice.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût de l'interprétariat pour un atelier, puis pour les quatre. Le budget est-il suffisant ? (3 pts)
2. Proposez quatre adaptations de l'animation pour les personnes malentendantes qui lisent sur les lèvres. (4 pts)
3. Proposez deux adaptations des supports de l'atelier. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi il faut construire l'atelier avec l'association plutôt que seul. (2 pts)
5. Proposez un outil d'évaluation accessible pour la fin de l'atelier. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.42 – Le club des seniors et le numérique (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un club de retraités (fictif) de 120 adhérents veut lancer un programme « Bien manger après 70 ans ». La mairie propose de tout faire par une application municipale : programme, inscriptions, recettes en vidéo. Avant de décider, le club a interrogé 80 adhérents présents au repas mensuel.

Document 1 – Résultats (n = 80, données fictives)

Usage	Effectif
A un smartphone	46
Utilise internet au moins une fois par semaine	39
A une adresse mail qu'il consulte	31
Utilise WhatsApp	28
N'a jamais utilisé internet	22
Souhaite recevoir le programme sur papier	61

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de chaque ligne du document 1. (3 pts)
2. Comparez la part d'adhérents qui n'ont jamais utilisé internet à la donnée nationale sur l'illectronisme. Expliquez l'écart et la prudence nécessaire. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi l'échantillon de 80 adhérents présents au repas peut sous-estimer les difficultés du club. (2 pts)
4. Proposez un plan de communication et d'inscription en quatre canaux pour le programme. (4 pts)
5. Proposez une action pour développer la littératie numérique des adhérents qui le souhaitent, avec un partenaire. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 5.37

1. Légendes : 1 Personne allophone ; 2 interprète professionnel, médiateur, supports traduits et testés ; 3 Difficultés numériques ; 4 version papier, téléphone, accompagnement (France Services) ; 5 Déficience intellectuelle ; 6 FALC relu par des personnes concernées, SantéBD ; 7 Déficience visuelle ; 8 contraste ≥ 4,5, gros caractères, audio, braille, lecteur d'écran ; 9 Lecture difficile ; 10 oral, pictogrammes, objets, démonstration, faire dire ; 11 Déficience auditive ; 12 sous-titres, langue des signes, écrit simple, visuel.
2. a) Invitation numérique lisible par un lecteur d'écran (texte réel, images décrites) ou appel téléphonique ; pendant l'atelier, description orale des gestes et repères tactiles. b) Interprète ou médiatrice parlant russe ou ukrainien, invitation traduite par un professionnel. c) Invitation en FALC avec photos, remise et expliquée par l'éducateur du foyer. d) Invitation écrite, sous-titres si une vidéo est utilisée, boucle magnétique si la salle en a une. e) Invitation papier et appel téléphonique, inscription au guichet. f) Invitation orale et carte avec pictogrammes, rappel par message vocal.
3. Ces adaptations aident les personnes qui en ont besoin, mais aussi les personnes pressées, fatiguées, âgées ou qui lisent dans une autre langue : c'est le principe des précautions universelles.

Corrigé – Exercice 5.38

1. Éditeur et financement : 0, financement par la publicité pour des compléments alimentaires, risque de conflit d'intérêts. Fondement scientifique : 0, algorithme non public, Nutri-Score officiel absent. Mise à jour : 0, base vieille de trois ans, beaucoup de recettes et de Nutri-Score ont changé depuis. Protection des données : 0, accès aux contacts sans raison et partage commercial. Accessibilité : 0, texte peu lisible et une seule langue (on peut accepter 1 si l'interface est simple). Effets indésirables : 0, messages alarmistes sur des aliments courants et incitation au comptage des calories, risque de culpabilisation et de restriction. Note : 0 sur 12 (au plus 1 sur 12 si l'on accorde 1 point à l'accessibilité).
2. Exemples : « Regardez qui a fait l'application et qui la paie. » « Une note sur un produit ne dit pas si votre repas est bon : un fromage ou du pain ne sont pas "à éviter". » « Refusez l'accès à vos contacts et à votre localisation. »
3. mangerbouger.fr, le site du Programme national nutrition santé géré par Santé publique France.

Corrigé – Exercice 5.39

1. 6 / 15 × 100 = 40,0 %.
2. Exemples de corrections rapides : augmenter le contraste du texte ; ajouter un texte alternatif aux 5 photos ; sous-titrer la vidéo ; rendre les liens explicites ; afficher le numéro de téléphone ; ajouter un mot ou un symbole en plus de la couleur pour les ateliers complets. Nouveau score : (6 + 6) / 15 × 100 = 80,0 %.
3. Texte courant : (1,0000 + 0,05) / (0,3185 + 0,05) = 1,05 / 0,3685 = 2,85 : non conforme. Bouton actuel : 1,05 / (0,3779 + 0,05) = 1,05 / 0,4279 = 2,45 : non conforme. Titre : 1,05 / (0,0542 + 0,05) = 1,05 / 0,1042 = 10,08 : conforme. Proposition pour le bouton : (0,3779 + 0,05) / (0,0331 + 0,05) = 0,4279 / 0,0831 = 5,15 : conforme.
4. Écrire le texte courant en gris très foncé ou en noir sur fond blanc (par exemple #333333, dont le ratio avec le blanc dépasse 12). Pour le bouton, le texte gris très foncé sur orange atteint 5,15 et respecte le seuil, tout en gardant la couleur repère des boutons de la page.
5. « Télécharger le programme des ateliers (PDF, 2 pages) » ; « Atelier complet » écrit à côté de chaque atelier concerné, avec un pictogramme, et pas seulement en vert.
6. Le public des ateliers du CCAS compte beaucoup de personnes âgées ou en difficulté, plus souvent concernées par l'illectronisme. Si l'inscription est seulement en ligne, ces personnes renoncent : les plus éloignées de la prévention restent exclues. Il faut garder une inscription par téléphone et à l'accueil.

Corrigé – Exercice 5.40

1. a) Non : faire traduire des enfants inverse les rôles familiaux, les expose à des informations qui ne les concernent pas et produit des erreurs. b) Non sans relecture : un traducteur automatique non relu peut produire des erreurs graves sur la santé ; le texte doit être traduit par un professionnel ou relu par un locuteur, puis testé. c) Oui : l'interprète professionnel garantit l'exactitude, la neutralité et la confidentialité. d) Oui : la médiatrice crée la confiance, fait venir les familles et explique les codes de la crèche ; elle complète l'interprète. e) Oui : les objets et les textures se comprennent sans langue commune. f) Oui : l'atelier aide à apprendre le français à partir d'un sujet concret qui intéresse les parents.

2. Une allergie peut mettre la vie de l'enfant en danger : il faut une traduction exacte, complète et neutre. L'interprète professionnel est formé à cela et tenu au secret ; la médiatrice n'est pas interprète et connaît peut-être la famille, ce qui peut gêner la confidentialité.

3. Exemple : montrer une frise avec des photos d'enfants de différents âges et demander à chaque parent, avec l'aide de l'interprète, de poser le premier petit pot à l'âge où il commencera. On réexplique si besoin. Rappel : la diversification commence entre 4 et 6 mois selon les repères de Santé publique France (2021).

Corrigé – Exercice 5.41

1. Un atelier : 2 interprètes × 2,5 h × 65 € = 325 €. Quatre ateliers : 4 × 325 = 1 300 €. Il reste 1 500 − 1 300 = 200 €, exactement le budget des courses : le budget est suffisant mais sans marge.

2. L'animatrice se place face au groupe, le visage éclairé (pas devant la fenêtre) ; elle parle sans exagérer l'articulation et sans se cacher la bouche ; elle arrête la hotte et le robot pendant les explications ; une personne parle à la fois ; elle montre le geste avant de l'expliquer ; elle écrit les mots clés au tableau.

3. Fiche recette en photos, avec très peu de texte ; vidéo de la recette sous-titrée ; mots clés écrits en gros ; minuteur visuel pour les temps de cuisson.

4. Les personnes concernées connaissent leurs besoins et leurs façons de communiquer ; l'association connaît les interprètes et les codes du groupe. Construire avec elles évite les erreurs, renforce la participation et le pouvoir d'agir, et permet de valider les supports.

5. Exemple : une échelle à smileys ou un vote avec des gommettes de couleur sur des photos des plats, avec une question posée en LSF par l'interprète.

Corrigé – Exercice 5.42

1. Smartphone : 46 / 80 = 57,5 % ; internet chaque semaine : 39 / 80 = 48,8 % ; adresse mail consultée : 31 / 80 = 38,8 % ; WhatsApp : 28 / 80 = 35,0 % ; jamais internet : 22 / 80 = 27,5 % ; programme papier souhaité : 61 / 80 = 76,3 %.

2. 27,5 % des adhérents n'ont jamais utilisé internet, contre 7 % des 16-74 ans en situation d'illectronisme en 2025 (Insee, 2026). L'écart s'explique par l'âge : l'illectronisme est beaucoup plus fréquent chez les plus âgés, et l'enquête nationale s'arrête à 74 ans. La comparaison doit rester prudente : les deux indicateurs ne sont pas définis de la même façon (« jamais utilisé » contre « pas d'usage d'internet ou aucune compétence numérique ») et le club n'est pas représentatif.

3. Les adhérents qui viennent au repas mensuel sont les plus mobiles et les plus en forme. Les 40 adhérents absents sont peut-être plus âgés, plus isolés ou malades, et sans doute encore plus éloignés du numérique.

4. Exemple : programme papier distribué au repas mensuel et envoyé par courrier aux absents ; inscription par téléphone auprès d'une bénévole et sur papier au club ; rappel par appel téléphonique ou message vocal la veille ; application municipale gardée en complément pour ceux qui l'utilisent, avec les vidéos de recettes sous-titrées.

5. Exemple : des ateliers « mon téléphone pas à pas » avec un conseiller numérique de France Services ou de

> la médiathèque, en petits groupes, pour apprendre à regarder une vidéo de recette et à s'inscrire en ligne. L'inscription papier reste possible pour ceux qui ne le souhaitent pas.

Partie 8 – Outils pédagogiques, littératie dans le projet et cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Intégrer la littératie à chaque étape du projet : diagnostic, objectifs, supports, animation, communication, évaluation.
- Analyser un outil pédagogique avec les huit questions du cours.
- Concevoir un outil de numératie (cartes-prix) et calculer des coûts par portion.
- Exploiter une évaluation sans écrit (smileys) et un budget de communication.
- Traiter un cas complet au format de l'épreuve.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Diagnostic : recueillir la langue, la lecture et le numérique ; questionnaire oral ou imagé.
- Objectifs : inclure des objectifs de compétences (« savoir lire le Nutri-Score », « savoir cuisiner les lentilles »).
- Supports : écriture claire, FALC, pictogrammes ; tester avant diffusion.
- Animation : méthodes actives, démonstration, binômes, faire dire.
- Communication : plusieurs canaux ; ne pas tout miser sur le numérique.
- Évaluation : outils sans écrit (smileys, gommettes, entretien) et indicateurs de compréhension.
- Huit questions avant d'utiliser un outil pédagogique : qui l'a conçu, contenu à jour, objectifs, public, participation, non-stigmatisation, accessibilité, adaptations.

Exercice 5.43 – La littératie à chaque étape du projet (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez avec une collègue un projet « Cuisiner de saison avec un petit budget » pour les habitants d'une résidence de logements sociaux (fictive). Vous voulez vérifier que la littératie est prise en compte à chaque étape.

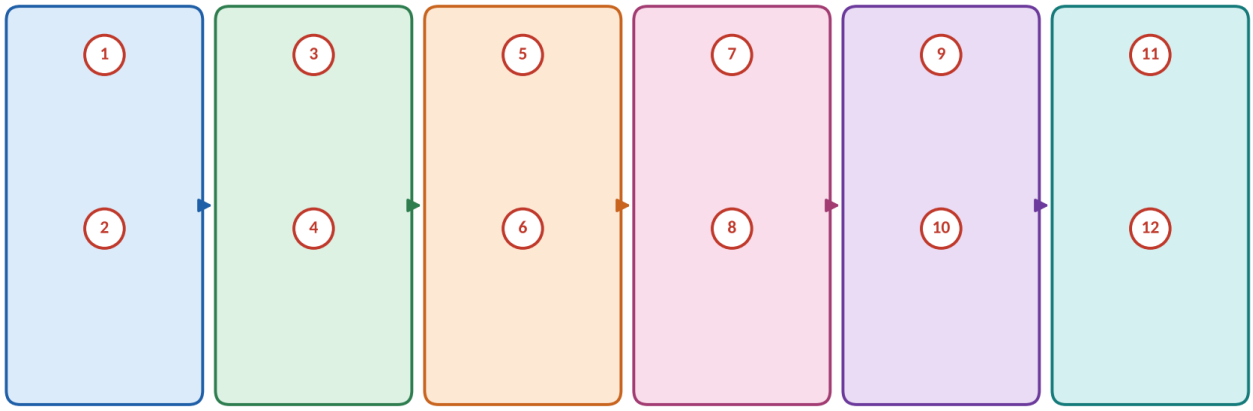


Figure 5.11 – Document 1 – La littératie à chaque étape du projet (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (6 pts)

2. Pour ce projet, proposez une action concrète pour chacune des six étapes. (3 pts)

3. Expliquez pourquoi il ne suffit pas de « simplifier les supports » à la fin du projet. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.44 – Analyser un kit pédagogique offert par une marque (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une école élémentaire a reçu gratuitement un kit pédagogique « Le goûter malin » (outil fictif), édité par une marque de biscuits. L'enseignante vous demande s'il peut servir pour un projet sur le goûter avec des familles dont beaucoup lisent peu le français.

Document 1 – Description du kit

- Un livret de 24 pages pour l'enseignant, très illustré, publié en 2016, qui cite les repères du PNNS de 2001.
- 30 cartes « aliments » avec photo ; 8 cartes montrent des biscuits de la marque, avec leur logo.
- Un jeu « le bon goûter » où les enfants reçoivent des points s'ils choisissent « le goûter équilibré », toujours composé d'un biscuit de la marque, d'un produit laitier et d'un fruit.
- Une affiche « Les aliments interdits » avec des bonbons, des chips et des sodas barrés en rouge, et le dessin d'un enfant en surpoids triste.
- Un dépliant pour les parents de 4 pages, en français seulement, en petits caractères.

À vous de jouer – Questions

1. Analysez le kit en répondant aux huit questions du cours. (6 pts)

2. Donnez votre conclusion : utiliser, adapter ou refuser le kit. Justifiez. (2 pts)

3. Citez une ressource pour trouver un outil pédagogique validé et indépendant. (1 pt)

4. Proposez une adaptation pour les familles qui lisent peu le français. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.45 – Créer des cartes-prix pour un jeu de numératie (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et production · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous concevez un jeu « Le dîner à 5 € pour 4 personnes » pour un atelier en centre social. Chaque carte montre la photo de l'aliment, la portion pour une personne et son prix. Vous avez relevé des prix dans un supermarché du quartier (relevé fictif).

Document 1 – Prix relevés et portions retenues

Aliment	Prix	Portion par personne
Lentilles vertes sèches	2,60 € le kg	60 g secs
Riz	1,80 € le kg	60 g crus
Carottes	1,40 € le kg	120 g
Pommes	2,20 € le kg	150 g
Pain complet	4,20 € le kg	50 g
Cuisses de poulet	6,50 € le kg	150 g
Fromage blanc	2,40 € le kg	100 g
Huile de colza	3,20 € le litre	10 mL
Œufs	3,30 € les 12	1 œuf
Yaourts nature	1,90 € les 8	1 yaourt

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le prix d'une portion de chaque aliment (au millième d'euro), puis arrondissez au centime pour l'écrire sur la carte. (4 pts)
2. Calculez le coût pour 4 personnes de ces trois dîners : A) lentilles, riz, carottes à l'huile, yaourt, pomme ; B) omelette de 2 œufs par personne, pain complet, carottes à l'huile, fromage blanc, pomme ; C) poulet, riz, carottes à l'huile, yaourt, pomme. Lesquels respectent les 5 € ? (4 pts)
3. Expliquez pourquoi on écrit sur les cartes le prix par portion et non le prix au kilo. (2 pts)
4. Proposez une règle du jeu qui fait discuter les participants sans les mettre en échec. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.46 – Évaluer avec des smileys (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un centre social (fictif), trois ateliers cuisine ont réuni au total 38 participations. À la fin de chaque atelier, les participants ont collé une gommette sur un smiley pour trois affirmations lues à voix haute et illustrées par une image.

Document 1 – Résultats cumulés des trois ateliers (38 participations, données fictives)

Affirmation	Smiley content	Smiley moyen	Smiley pas content
« J'ai aimé l'atelier »	31	6	1
« J'ai compris la recette »	24	11	3
« Je vais refaire la recette à la maison »	19	13	6

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de chaque case du document 1. (3 pts)
2. Décrivez l'évolution des résultats d'une affirmation à l'autre et proposez une explication. (2 pts)
3. Proposez deux ajustements des ateliers à partir de ces résultats. (2 pts)
4. Citez deux limites de cet outil. (2 pts)
5. Proposez deux indicateurs complémentaires, dont un indicateur de compréhension, et l'outil pour les recueillir sans écrit. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.47 – Un budget de communication accessible (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez la communication d'un cycle d'ateliers « familles et cuisine » dans un quartier où vivent environ 1 200 familles, dont beaucoup parlent une autre langue que le français. Le budget de communication est de 300 €. Vous avez obtenu des devis (données fictives).

Document 1 – Actions prévues et coûts

Action	Quantité	Coût unitaire
Affiches A3 avec photos et pictogrammes	20	0,90 €
Cartes d'invitation illustrées à remettre en main propre	300	0,08 €
Kakémono pour le marché et l'école	1	65,00 €
Collation pour 3 réunions avec des habitants relais	3	18,00 €
Traduction orale d'une vidéo courte en deux langues par une professionnelle	1	120,00 €

Document 2 – Résultats attendus

Environ 180 personnes devraient recevoir l'information directement (relais, cartes, marché) ; on vise 42 participants sur le cycle.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût de chaque action et le coût total. Le budget est-il respecté ? (3 pts)
2. Calculez le coût par personne informée et par participant visé. (2 pts)
3. Justifiez chaque action du point de vue de la littératie. (3 pts)
4. Proposez deux canaux gratuits supplémentaires. (2 pts)
5. Proposez un indicateur pour savoir quels canaux ont fait venir les participants, et la façon de le recueillir sans écrit. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.48 – Cas complet : cuisiner le colis au centre d'hébergement (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 1 h 45*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes diététicien en stage dans une association qui gère un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), « Le Relais des Lilas » (données fictives). Il héberge 24 familles, soit 24 adultes référents et 41 enfants de 0 à 10 ans, dans des appartements avec une cuisine partagée par étage. Chaque semaine, les familles reçoivent un colis d'une banque alimentaire. Les travailleurs sociaux constatent que les boîtes de haricots rouges du colis sont souvent données ou jetées. L'association vous confie un projet d'ateliers « Cuisiner le colis ».

Document 1 – Diagnostic mené en entretien oral auprès des 24 adultes référents (données fictives)

Réponse	Nombre d'adultes
Lit difficilement le français	14
Parle une autre langue à la maison	17
Utilise WhatsApp	19
N'a pas de smartphone	5
Cuisine un repas « fait maison » 3 fois par semaine ou moins	15
Dispose de moins de 4 € par jour et par personne pour l'alimentation	16

Document 2 – Paroles recueillies

- « Les boîtes de haricots rouges, je ne sais pas quoi en faire. Je les donne à la voisine. »
- « Le papier de l'atelier de l'an dernier, je ne l'ai pas lu. Trop de mots. »
- « C'est mon fils qui lit les papiers pour moi. »
- « Chez moi, on fait du riz avec une sauce tomate. Mes enfants adorent. »
- « Sur internet, ils disent que les conserves, c'est du poison. »

Document 3 – L'invitation de l'an dernier

« Dans le cadre du programme d'accompagnement à l'autonomie alimentaire, l'association propose aux personnes hébergées un cycle d'ateliers culinaires visant à favoriser l'utilisation optimale des denrées distribuées par la banque alimentaire… » Comptage du texte entier : 142 mots, 5 phrases, 255 syllabes. Nouvelle version préparée avec deux mères hébergées : 70 mots, 10 phrases, 102 syllabes.

Document 4 – Recette « chili sans viande » pour 8 portions : quantités par portion et données (Ciqual 2025 pour 100 g ; prix relevés, fictifs)

Ingrédient (code Ciqual)	Par portion	kcal	Protéines (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Vitamine C (mg)	Prix
Haricot rouge, appertisé, égoutté (20524)	120 g	108	8,31	7	0,68	0,2	colis (valeur : 3,56 € le kg)
Riz blanc, cru (9100)	60 g	350	7,02	1,53	0,0079	0	colis (valeur : 1,80 € le kg)
Tomate, purée, appertisée (20170)	80 g	47,6	1,5	1,6	0,42	9	colis (valeur : 1,60 € le kg)

Ingrédient (code Ciqual)	Par portion	kcal	Protéines (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Vitamine C (mg)	Prix
Oignon, cru (20034)	30 g	39	1,1	1,7	0,098	3,9	1,80 € le kg, 10 % de pertes
Poivron rouge, cru (20087)	50 g	33,6	1,06	3,2	< 0,013	121	4,50 € le kg, 20 % de pertes
Huile de colza (17130)	5 g	900	0	0	< 0,0028	0	3,20 € le kg
Pomme, chair et peau, crue (13039)	150 g	54	0,25	1,4	0,0037	4,6	2,20 € le kg
Cumin, ail, épices							forfait 0,30 € pour 8

Les valeurs « < » sont comptées 0. Les quantités du tableau sont des quantités nettes.

Document 5 – Premier atelier : présence et « faire dire » (données fictives)

24 adultes invités, 9 présents. À la fin, l'animatrice note les réussites : expliquer comment rincer et utiliser les haricots rouges, 7 sur 9 ; dire le prix d'une portion à 20 centimes près, 4 sur 9 ; citer un plat à refaire avec les haricots, 8 sur 9.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de chaque réponse du document 1 et le taux de présence au premier atelier (document 5). (4 pts)
2. Analysez les besoins de littératie de ces familles avec trois notions du chapitre : les dimensions de Sørensen, les niveaux de Nutbeam et les domaines de la littératie alimentaire. Appuyez-vous sur des éléments précis des documents. (6 pts)
3. Calculez l'indice de lisibilité des deux versions de l'invitation (document 3) et rédigez la nouvelle invitation en écriture claire, avec les images prévues. (5 pts)
4. À partir du document 4, calculez pour une portion l'énergie, les protéines, les fibres, le sel et la vitamine C, puis la part de l'énergie apportée par les protéines. Calculez le coût de la recette pour 8 portions et par portion, en valeur totale puis pour la seule partie achetée par les familles. Commentez. (7 pts)
5. Construisez le déroulé d'un atelier de 2 heures sur cette recette, avec pour chaque étape l'adaptation de littératie et le moment du « faire dire ». (6 pts)
6. Exploitez les résultats du « faire dire » du document 5 et proposez deux ajustements. (4 pts)
7. Proposez un plan de communication en trois canaux pour augmenter la présence au deuxième atelier. Justifiez avec les chiffres. (3 pts)
8. Proposez deux indicateurs d'évaluation accessibles et deux règles éthiques à respecter dans ce projet. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 5.43

1. Légendes : 1 Diagnostic ; 2 recueillir langue, lecture, numérique ; questionnaire oral ou imagé ; 3 Objectifs ; 4 inclure des compétences : lire le Nutri-Score, cuisiner les lentilles ; 5 Supports ; 6 écriture claire, FALC, pictogrammes, test avant diffusion ; 7 Animation ; 8 méthodes actives, démonstration, binômes, faire dire ; 9 Communication ; 10 plusieurs canaux : oral, affiches, relais, numérique accompagné ; 11 Évaluation ; 12 outils sans écrit : smileys, gommettes, entretien, indicateurs de compréhension.
2. Exemples : diagnostic : entretiens en porte-à-porte avec la gardienne, questions sur la langue et la façon de recevoir les informations ; objectifs : « savoir choisir trois légumes de saison au marché et préparer une soupe pour moins de 1 € la portion » ; supports : calendrier des légumes de saison en photos, testé par trois habitants ; animation : démonstration puis cuisine en binômes, faire dire en fin de séance ; communication : affiche dans le hall, invitation remise par la gardienne, message vocal ; évaluation : smileys et question orale « Qu'allez-vous refaire ? ».
3. La littératie se prend en compte dès le diagnostic : si l'on ne sait pas quelles langues et quels supports conviennent, on choisit de mauvais objectifs, de mauvais canaux et de mauvaises méthodes. Simplifier un support à la fin ne rattrape pas ces choix.

Corrigé – Exercice 5.44

1. Qui l'a conçu : une marque de biscuits, qui a un intérêt commercial. Contenu : publié en 2016 avec les repères de 2001, il n'est pas à jour (repères du PNNS révisés en 2019). Objectifs : il cherche à faire choisir un biscuit de la marque, pas à développer l'autonomie des enfants. Public : les enfants, mais le dépliant parents n'est pas adapté à des familles qui lisent peu le français. Participation : le jeu fait participer, mais avec une seule bonne réponse imposée. Non-stigmatisation : l'affiche « aliments interdits » culpabilise et le dessin d'un enfant en surpoids triste stigmatise. Accessibilité : beaucoup d'images, mais dépliant en petits caractères et en français seulement. Adaptations : il faudrait retirer les logos, refaire le jeu, supprimer l'affiche, refaire le dépliant.
2. Refuser le kit : son objectif est publicitaire, son contenu n'est pas à jour et certains éléments sont stigmatisants. Les adaptations seraient si nombreuses qu'il vaut mieux choisir un autre outil. Les cartes photos d'aliments sans logo peuvent éventuellement être réutilisées.
3. La pédagothèque de l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé (IREPS) de la région, qui prête des outils analysés.
4. Exemple : une invitation et une fiche goûter en photos, présentées à l'oral à la sortie de l'école avec une médiatrice, et un goûter partagé où les parents goûtent les propositions.

Corrigé – Exercice 5.45

1. Lentilles : 2,60 × 60 / 1 000 = 0,156 €, soit 0,16 € ; riz : 0,108 €, soit 0,11 € ; carottes : 0,168 €, soit 0,17 € ; pommes : 0,330 €, soit 0,33 € ; pain complet : 0,210 €, soit 0,21 € ; poulet : 0,975 €, soit 0,98 € ; fromage blanc : 0,240 €, soit 0,24 € ; huile : 3,20 × 10 / 1 000 = 0,032 €, soit 0,03 € ; œuf : 3,30 / 12 = 0,275 €, soit 0,28 € ; yaourt : 1,90 / 8 = 0,2375 €, soit 0,24 €.
2. A : 4 × (0,156 + 0,108 + 0,168 + 0,032) + 4 × 0,2375 + 4 × 0,330 = 1,856 + 0,950 + 1,320 = 4,13 €. B : 4 × 2 × 0,275 + 4 × 0,210 + 4 × 0,168 + 4 × 0,032 + 4 × 0,240 + 4 × 0,330 = 2,200 + 0,840 + 0,672 + 0,128 + 0,960 + 1,320 = 6,12 €. C : 4 × 0,975 + 4 × 0,108 + 4 × 0,168 + 4 × 0,032 + 0,950 + 1,320 = 3,900 + 0,432 + 0,672 + 0,128 + 0,950 + 1,320 = 7,40 €. Seul le dîner A respecte les 5 € (1,03 € par personne).
3. Le prix au kilo demande un calcul que beaucoup de participants trouvent difficile, et il ne dit pas ce que coûte réellement l'assiette. Le prix par portion se lit directement et s'additionne facilement : c'est une adaptation à la numératie.
4. Exemple : les équipes composent un dîner, additionnent les cartes et présentent leur choix ; il n'y a pas de

« mauvaise réponse », chaque équipe explique ses choix et le groupe cherche ensemble comment rester sous 5 € en gardant un plat qui plaît. On peut garder les prix arrondis et utiliser de vraies pièces de monnaie.

Corrigé – Exercice 5.46

1. « J'ai aimé » : 31 / 38 = 81,6 % ; 6 / 38 = 15,8 % ; 1 / 38 = 2,6 %. « J'ai compris » : 63,2 % ; 28,9 % ; 7,9 %. « Je vais refaire » : 50,0 % ; 34,2 % ; 15,8 %.
2. Les smileys contents diminuent de l'affirmation 1 à l'affirmation 3 (81,6 %, puis 63,2 %, puis 50,0 %). Les participants aiment l'atelier, mais une partie n'est pas sûre d'avoir compris la recette, et encore moins de pouvoir la refaire à la maison : manque d'ingrédients, de matériel, de temps ou de confiance.
3. Exemples : ajouter un « faire dire » sur chaque étape de la recette et remettre une fiche en photos ; choisir des recettes avec des ingrédients du quotidien et peu chers ; terminer par la question « Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de la refaire ? » pour lever les freins.
4. Les participants peuvent coller la gommette sur le smiley content par politesse ou en imitant le voisin ; l'outil mesure une impression et une intention, pas un changement réel ; il ne dit pas pourquoi.
5. Indicateur de compréhension : part des participants qui réussissent le « faire dire » sur la recette (grille d'observation de l'animatrice). Indicateur de résultat : part des participants qui ont refait la recette dans le mois, recueillie à l'oral au début de l'atelier suivant ou par une photo du plat envoyée par message.

Corrigé – Exercice 5.47

1. Affiches : 20 × 0,90 = 18,00 € ; cartes : 300 × 0,08 = 24,00 € ; kakémono : 65,00 € ; collations : 3 × 18,00 = 54,00 € ; vidéo traduite : 120,00 €. Total : 281,00 €, inférieur aux 300 € : le budget est respecté (il reste 19,00 €).
2. Par personne informée : 281 / 180 = 1,56 €. Par participant visé : 281 / 42 = 6,69 €.
3. Affiches avec photos et pictogrammes : compréhensibles sans bien lire. Cartes remises en main propre : l'invitation s'accompagne d'une explication orale. Kakémono au marché et à l'école : visible là où les familles passent. Réunions avec des habitants relais : le bouche-à-oreille par des personnes de confiance est très efficace auprès des familles qui lisent peu ou qui parlent une autre langue. Vidéo traduite oralement : touche les personnes qui ne lisent pas le français, et se partage facilement sur les téléphones.
4. Annonce orale à la sortie de l'école et au marché par l'animatrice ; message vocal partagé dans les groupes WhatsApp des parents par les relais ; annonce par les travailleurs sociaux et la PMI du quartier.
5. Indicateur : répartition des participants selon le canal qui les a fait venir. Recueil : au premier atelier, chaque participant pose une gommette sur l'image du canal (affiche, carte, voisin, vidéo, école).

Corrigé – Exercice 5.48

1. Document 1 : lit difficilement 14 / 24 = 58,3 % ; autre langue 17 / 24 = 70,8 % ; WhatsApp 19 / 24 = 79,2 % ; sans smartphone 5 / 24 = 20,8 % ; fait maison 3 fois par semaine ou moins 15 / 24 = 62,5 % ; moins de 4 € par jour et par personne 16 / 24 = 66,7 %. Présence au premier atelier : 9 / 24 = 37,5 %.
2. Sørensen : les familles accèdent à l'aliment (le colis) mais pas à l'information pour l'utiliser ; elles ont du mal à comprendre l'écrit (« trop de mots ») ; l'évaluation est difficile (« les conserves, c'est du poison ») ; l'application est bloquée (« je ne sais pas quoi en faire »). Domaine : prévention et promotion de la santé. Nutbeam : la littératie fonctionnelle en français est limitée (58,3 % lisent difficilement, le fils lit les papiers) ; la littératie interactive existe (les familles échangent entre voisines, savent dire ce que leurs enfants aiment) ; la littératie critique est à développer (rumeur sur les conserves). Littératie alimentaire : le domaine « préparer » est le plus en difficulté (haricots non cuisinés, fait maison 3 fois ou moins pour 62,5 %) ; « planifier et gérer » est contraint par le budget (66,7 % sous 4 €) ; « sélectionner » est limité car le colis est imposé ; « manger » s'appuie sur des habitudes culturelles fortes (riz et sauce tomate) qui

sont une ressource.

3. Ancienne version : 142 / 5 = 28,4 mots par phrase ; 255 / 142 = 1,796 syllabe par mot ; L = 207 − 1,015 × 28,4 − 73,6 × 1,796 = 207 − 28,83 − 132,17 = 46,00 : difficile. Nouvelle version : 70 / 10 = 7 ; 102 / 70 = 1,457 ; L = 207 − 7,11 − 107,25 = 92,65 : très facile. Gain : 46,64 points. Exemple d'invitation : « Atelier cuisine. Mardi 14 h. Cuisine du 1er étage. On cuisine les haricots rouges du colis. On fait un plat avec du riz et de la tomate. Vos enfants peuvent goûter. C'est gratuit. Venez avec une boîte : vous repartez avec un plat. Questions ? Demandez à Fatou. » Images : une photo de la boîte de haricots rouges, une photo du plat, un pictogramme horloge, une photo de la cuisine, une photo de l'animatrice.

4. Énergie : 129,60 + 210,00 + 38,08 + 11,70 + 16,80 + 45,00 + 81,00 = 532,18 kcal, soit 532 kcal. Protéines : 9,97 + 4,21 + 1,20 + 0,33 + 0,53 + 0 + 0,38 = 16,62 g. Fibres : 8,40 + 0,92 + 1,28 + 0,51 + 1,60 + 0 + 2,10 = 14,81 g. Sel : 0,82 + 0,00 + 0,34 + 0,03 + 0 + 0 + 0,01 = 1,19 g. Vitamine C : 0,24 + 0 + 7,20 + 1,17 + 60,50 + 0 + 6,90 = 76,01 mg. Protéines : 16,62 × 4 / 532,18 × 100 = 12,5 % de l'énergie. Coût (quantités pour 8 portions) : haricots 960 g × 3,56 € / kg = 3,42 € ; riz 480 g = 0,86 € ; purée 640 g = 1,02 € ; oignon 240 / 0,90 = 266,7 g bruts = 0,48 € ; poivron 400 / 0,80 = 500 g bruts = 2,25 € ; huile 40 g = 0,13 € ; pommes 1 200 g = 2,64 € ; épices 0,30 €. Valeur totale : 11,10 €, soit 1,39 € par portion. Partie achetée par les familles (oignon, poivron, huile, pommes, épices) : 0,48 + 2,25 + 0,13 + 2,64 + 0,30 = 5,80 €, soit 0,72 € par portion. Commentaire : le plat est complet et rassasiant, riche en fibres (14,81 g, environ la moitié des 30 g par jour) et en vitamine C grâce au poivron (76 mg, environ 69 % des 110 mg recommandés par l'ANSES pour un adulte), peu salé (1,19 g, soit 23,8 % du repère de l'OMS de 5 g par jour). Les protéines sont modérées (12,5 %) : on peut ajouter un yaourt ou un morceau de fromage. Rincer les haricots en conserve réduit encore le sel. Le plat reprend « riz et sauce tomate », déjà aimé des enfants, et coûte moins de 1 € par portion pour les familles.

5. Exemple de déroulé de 120 minutes : 10 min, accueil individuel, consignes d'hygiène montrées en pictogrammes, médiatrice présente ; 10 min, photolangage « Montrez la photo du plat que vous faites le plus souvent » ; 10 min, message principal avec objets réels : boîte de haricots, riz, tomate, « un plat complet pour moins de 1 € » ; 10 min, démonstration : ouvrir, rincer et égoutter les haricots, couper l'oignon, faire revenir ; 40 min, cuisine en binômes (une personne qui lit le français avec une personne qui le lit peu), recette en 6 photos, quantités en verres et cuillères ; 20 min, dégustation avec les enfants, échelle à smileys ; 15 min, faire dire : chaque binôme montre comment il rince les haricots et dit le prix d'une portion, l'animatrice réexplique autrement si besoin ; 5 min, clôture : fiche en photos, boîte de plat à emporter, date suivante dite à l'oral. Total : 10 + 10 + 10 + 10 + 40 + 20 + 15 + 5 = 120 minutes.

6. Rincer et utiliser les haricots : 7 / 9 = 77,8 % ; prix d'une portion : 4 / 9 = 44,4 % ; plat à refaire : 8 / 9 = 88,9 % ; moyenne 19 / 27 = 70,4 %. Le geste et l'envie de refaire sont acquis ; le prix d'une portion, une compétence de numératie, l'est beaucoup moins. Ajustements : afficher le prix par portion de chaque ingrédient sur des étiquettes et faire l'addition avec des pièces ; refaire la démonstration du rinçage pour les deux personnes qui ne l'ont pas réussie, en binôme avec une personne qui l'a réussie.

7. Seulement 37,5 % des familles sont venues. Canaux : un message vocal WhatsApp en français et dans les deux langues les plus parlées, enregistré par une mère qui est venue (79,2 % utilisent WhatsApp) ; une invitation orale par les travailleurs sociaux lors des rendez-vous, avec la carte en images (pour les 20,8 % sans smartphone et les 58,3 % qui lisent difficilement) ; une dégustation du plat dans le hall le jour de la distribution du colis, pour donner envie.

8. Indicateurs : part des familles qui déclarent à l'oral avoir cuisiné les haricots rouges dans les deux semaines (objectif : la moitié des participants) ; nombre de boîtes de haricots rouges laissées ou données après la distribution, relevé par les bénévoles avant et après le cycle ; réussite des « faire dire ». Règles éthiques : respect des habitudes culturelles et des choix des familles, sans jugement sur leur budget ou leur cuisine ; confidentialité des informations recueillies au diagnostic (lecture, langue) ; participation libre, sans lien avec l'hébergement ; pas d'enfant utilisé comme interprète pendant les ateliers.

Bilan : grille d'auto-évaluation

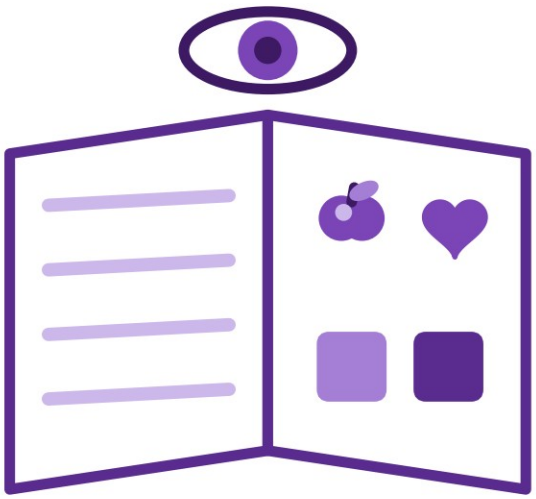
Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Définir la littératie en santé (Sørensen) et la littératie alimentaire ; situer les trois niveaux de Nutbeam ; distinguer littératie individuelle et organisationnelle ; analyser un diagnostic avec la grille des 12 dimensions	5.1 à 5.6			
2	Citer et interpréter HLS19, l'illettrisme et l'illectronisme sans les additionner ; décrire les conséquences d'une littératie limitée ; repérer un gradient social ; calculer un risque relatif ; appliquer l'universalisme proportionné	5.7 à 5.12			
3	Appliquer les précautions universelles ; reconnaître des signaux sans les surinterpréter ; poser des questions qui n'humilient pas ; adapter un questionnaire de diagnostic et comparer deux modes de passation	5.13 à 5.18			
4	Suivre les six étapes d'une communication accessible ; écrire clair ; rédiger en FALC ; calculer et interpréter l'indice de Kandel et Moles et ses limites	5.19 à 5.24			
5	Conduire la boucle du « faire dire » ; transformer une question fermée ; construire un atelier accessible de 2 heures ; exploiter une grille de réussite ; rédiger un message oral	5.25 à 5.30			
6	Lire une étiquette et une liste d'ingrédients ; convertir les sucres en morceaux ; comparer pour 100 g et par portion ; présenter un risque en fréquences naturelles ; traduire un repère chiffré en aliments	5.31 à 5.36			
7	Choisir une adaptation selon la langue, le numérique ou le handicap ; évaluer une application ; calculer un ratio de contraste ; travailler avec un interprète ; construire une communication qui n'exclut personne	5.37 à 5.42			
8	Intégrer la littératie à chaque étape du projet ; analyser un outil pédagogique ; créer des cartes-prix ; évaluer sans écrit ; traiter un cas complet	5.43 à 5.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5



05

CHAPITRE

05

Littératie en santé

Littératie en santé | Repérer | Adapter | Vérifier la compréhension

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 5 230
Mode d'emploi du cahier d'annales 230
Ce que le jury attend sur ce chapitre 230
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 231
S1 – « Les papiers, c'est ma fille qui les lit » : littératie en santé sur deux aires d'accueil des gens du voyage 231
S2 – « Cuisiner pour apprendre le français » : un atelier avec un groupe d'apprenants en ateliers sociolinguistiques 235
S3 – « Voir avec les mains » : alimentation, information et autonomie de personnes déficientes visuelles 238
Partie II – Les corrigés détaillés 242
Corrigé S1 – « Les papiers, c'est ma fille qui les lit » : littératie en santé sur deux aires d'accueil des gens du voyage 242
Corrigé S2 – « Cuisiner pour apprendre le français » : un atelier avec un groupe d'apprenants en ateliers sociolinguistiques 248
Corrigé S3 – « Voir avec les mains » : alimentation, information et autonomie de personnes déficientes visuelles 253
Grille d'auto-évaluation 260

Cahier d'annales E5 – chapitre 5

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes et les données des enquêtes sont fictives : elles sont construites pour l'entraînement et ne doivent pas être citées comme des données réelles. Les données nationales et les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Les papiers, c'est ma fille qui les lit » : littératie en santé sur deux aires d'accueil des gens du voyage	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Cuisiner pour apprendre le français » : un atelier avec un groupe d'apprenants en ateliers sociolinguistiques	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Voir avec les mains » : alimentation, information et autonomie de personnes déficientes visuelles	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 5 porte sur la littératie en santé : définitions (Sørensen, Nutbeam, littératie alimentaire), données françaises (HLS19, illettrisme, illectronisme), lien avec les inégalités sociales de santé, repérage sans stigmatisation (précautions universelles), adaptation des messages et des supports (écriture claire, FALC, pictogrammes, lisibilité, accessibilité numérique), vérification de la compréhension (faire dire), numératie et littératie numérique. Le jury vérifie que le candidat sait **mesurer** les difficultés d'un public sans le juger (questionnaire oral, test de compréhension, indice de lisibilité), **adapter** un support et une animation, puis **vérifier** que le message a été compris, en considérant que la clarté est d'abord la responsabilité du professionnel et de l'organisation.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; surligner le public, ses ressources (langues parlées, entraide, oral, smartphone), ses obstacles (écrit, chiffres, démarches en ligne, handicap) et le verbe de chaque consigne. Pendant : pour chaque donnée, écrire le calcul, le résultat et une phrase d'interprétation qui nomme une notion du chapitre (dimension de Sørensen, niveau de Nutbeam, numératie, illectronisme, précautions universelles, lisibilité) et l'adaptation qui en découle. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Les papiers, c'est ma fille qui les lit » : littératie en santé sur deux aires d'accueil des gens du voyage

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II).

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année à l'association « Chemins de santé » (structure fictive), qui emploie deux médiatrices en santé auprès des familles des deux aires d'accueil des gens du voyage de l'agglomération du Val de Sorne (territoire fictif). La responsable vous confie une demande issue d'une réunion avec le service de protection maternelle et infantile (PMI) et le cabinet dentaire mobile du département : « Beaucoup d'enfants ont des caries, ils boivent des sodas et des jus toute la journée. Les mères nous disent qu'elles ne comprennent pas nos dépliants, et plusieurs adultes diabétiques ne savent pas lire leurs ordonnances. Nos documents ne servent à rien. » Vous devez analyser la situation sous l'angle de la littératie en santé, concevoir un projet, en réaliser une partie pendant votre stage et en rendre compte dans votre dossier E5.

Document 1 – Le territoire, le public et les moyens

- Deux aires d'accueil (64 emplacements au total), gérées par l'agglomération ; en hiver, environ 52 familles sont présentes, soit environ 220 personnes, dont 140 adultes de 18 ans ou plus. Les familles voyagent surtout d'avril à octobre.
- Chaque emplacement dispose d'un bloc sanitaire et d'un branchement électrique payant ; les familles cuisinent dans leur caravane ou à l'extérieur. Les courses se font au supermarché de la zone commerciale, à 3 km.
- La scolarisation des enfants est irrégulière, en particulier au collège ; une partie des adultes n'a pas ou peu été scolarisée.
- Ressources : deux médiatrices, dont l'une est elle-même issue de la communauté ; un local associatif sur l'aire principale (une salle de 30 m², un évier, deux plaques électriques, un réfrigérateur) ; partenaires : PMI, cabinet dentaire mobile, maison de santé, centre social, Éducation nationale.
- Budget de l'action : 1 800 € pour l'année (hors salaires).

Document 2 – Questionnaire administré oralement par les médiatrices (données fictives)

Les médiatrices ont interrogé 74 adultes volontaires, en entretien oral, avec six questions inspirées de l'enquête HLS19 (« Est-ce facile, plutôt facile, plutôt difficile ou très difficile pour vous de… ») et trois questions sur l'écrit et le numérique.

Question	Réponses « plutôt difficile » ou « très difficile » (n = 74)
Comprendre la notice d'un médicament	41
Remplir un formulaire administratif (CAF, Assurance maladie)	52

Question	Réponses « plutôt difficile » ou « très difficile » (n = 74)
Trouver une information de santé sur internet	49
Juger si une information de santé vue à la télévision ou sur les réseaux sociaux est fiable	44
Comprendre ce que dit le médecin pendant la consultation	18
Comprendre les informations sur les emballages des aliments	46

Écrit et numérique	Réponses « oui » (n = 74)
Possède un smartphone	68
Sait utiliser une application de santé (Mon espace santé, prise de rendez-vous)	15
Déclare lire le français couramment	30

À partir de leurs réponses, les médiatrices ont classé les 74 adultes selon le niveau de littératie en santé générale (méthode de score simplifiée inspirée du HLS19) : insuffisant 26 ; problématique 28 ; suffisant 20.

Document 3 – Le dépliant de la PMI « Les boissons sucrées » et un test de compréhension (données fictives)

- Version actuelle : 180 mots, 7 phrases, 324 syllabes ; texte justifié en police de 9 points ; trois sigles (PNNS, OMS, AJR) ; une photo de bouteilles sans légende.
- Version réécrite par les médiatrices et vous : 90 mots, 13 phrases, 130 syllabes ; police de 14 points ; quatre pictogrammes (verre d'eau, bouteille de soda, morceaux de sucre, dent).
- Test auprès de 20 mères (10 par version, puis croisement des versions) : à la question « Combien de verres de jus de fruits par jour au maximum pour un enfant ? », 6 bonnes réponses sur 20 avec la version actuelle ; 16 sur 20 avec la version réécrite.
- Indice de lisibilité de Kandel et Moles : L = 207 − 1,015 × (mots / phrases) − 73,6 × (syllabes / mots).

Document 4 – Caries et boissons sucrées chez les enfants vus par le cabinet dentaire mobile (données fictives)

Le cabinet dentaire mobile a examiné 60 enfants de 3 à 11 ans des deux aires. Les parents ont indiqué si l'enfant boit des sodas ou des boissons sucrées tous les jours.

- Enfants qui boivent des boissons sucrées tous les jours : 34, dont 21 ont au moins une carie non soignée.
- Enfants qui n'en boivent pas tous les jours : 26, dont 6 ont au moins une carie non soignée.

Document 5 – Paroles recueillies pendant le stage

« Les papiers, c'est ma fille qui les lit. Elle a douze ans, elle sait mieux que moi. » (Mme R., 41 ans)

« Le docteur parle vite. Je dis oui, oui, et après je demande à la pharmacienne. » (M. L., 58 ans, diabétique)

« Le jus, c'est bon pour les enfants, c'est des fruits. C'est marqué dessus. » (Mme D., 29 ans)

« Les vidéos sur le téléphone, ça on regarde, oui. Pas les papiers. » (Mme S., 34 ans)

« On n'aime pas trop les bureaux. Si c'est Sandra qui vient ici, on écoute. » (Mme P., 52 ans, à propos de la médiatrice)

« Mon garçon, il a eu mal aux dents tout l'hiver. On attendait de repartir pour voir un dentiste ailleurs. »

(Mme V., 36 ans)

Document 6 – Trois situations rencontrées pendant le stage

Un agent de la mairie vous demande la liste des familles « dont les enfants ont des caries » pour « signaler les familles négligentes ». Une start-up propose de prêter gratuitement des tablettes équipées de son application de « coaching nutritionnel », en échange des données d'utilisation des familles. Une étudiante en journalisme souhaite photographier les enfants pendant votre atelier pour un reportage sur « les voyageurs et la malbouffe ».

Document 7 – Cadre et repères (données réelles)

- La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage organise les aires d'accueil ; la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a supprimé les titres de circulation qui leur étaient imposés.
- La médiation en santé est reconnue par l'article L. 1110-13 du Code de la santé publique (loi du 26 janvier 2016) ; la HAS a publié en 2017 un référentiel de compétences, de formation et de bonnes pratiques.
- Enquête HLS19 (résultats français publiés en 2021) : environ 44 % des adultes ont une littératie en santé générale limitée (problématique ou insuffisante).
- Insee (enquête 2025, publiée le 19 février 2026) : 7 % des 16-74 ans sont en situation d'illectronisme et 34 % ont des difficultés numériques.
- L'OMS (2015) recommande de limiter les sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique, et idéalement à moins de 5 %, notamment pour prévenir la carie dentaire.
- Santé publique France a publié en 2018, et mis à jour en février 2025, le guide « Communiquer pour tous » pour une information en santé accessible.

Travail à faire

Partie A – Le projet d'intervention (dossier écrit de 10 pages au plus) – C3.1 (9 points)

1. Calculez les indicateurs du document 2 et le taux de participation des adultes ; calculez la part de littératie limitée et comparez-la avec la donnée nationale. Classez les six questions selon les quatre compétences du modèle de Sørensen et posez le diagnostic. (2 pts)
2. Calculez l'indice de lisibilité des deux versions du dépliant et les taux de bonnes réponses au test de compréhension (document 3). Interprétez les résultats et dites ce que chaque mesure apporte et ne dit pas. (2 pts)
3. Analysez la situation avec les notions du chapitre : niveaux de Nutbeam, littératie alimentaire, numératie, illectronisme, littératie organisationnelle, inégalités sociales de santé et ressources du public. Formulez le problème central, ses causes et ses conséquences. (2 pts)
4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et des objectifs opérationnels, chacun avec un indicateur, une valeur cible et une échéance. (1,5 pt)
5. Présentez le plan d'action sur un an, construit avec les familles et les médiatrices, en tenant compte des périodes de voyage, et un budget qui respecte les 1 800 €. Justifiez chaque action par une notion du chapitre. (1,5 pt)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée – C3.3 (3 points)

6. Calculez la prévalence des caries, le risque relatif de carie selon la consommation quotidienne de boissons sucrées et son intervalle de confiance à 95 %, avec la formule : IC = exp(ln RR ± 1,96 × √(1/a − 1/(a + b) + 1/c − 1/(c + d))). Interprétez. Pourquoi ne peut-on pas conclure à une relation de cause à effet ? (1,5 pt)

7. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion d'adultes ayant une littératie limitée et la taille d'échantillon nécessaire pour une précision de ± 5 points, avec correction pour une population de 140 adultes. Présentez trois limites d'un questionnaire administré oralement par les médiatrices. (1,5 pt)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

8. Organisez une veille sur la littératie en santé, la santé des gens du voyage et la communication accessible : sources fiables, outils, fréquence, diffusion. (2 pts)

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique – C3.5 et C3.6 (3 points)

9. Analysez les trois situations du document 6 (secret professionnel, stigmatisation, données personnelles, droit à l'image des mineurs) et rédigez votre réponse à chacun des demandeurs. (1,5 pt)

10. Proposez des supports et des canaux adaptés à ce public (oral, vidéo, pictogrammes, médiation) ; rédigez la trame minutée de votre exposé de 10 minutes et listez 15 questions probables du jury. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Cuisiner pour apprendre le français » : un atelier avec un groupe d'apprenants en ateliers sociolinguistiques

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des sujets U62 et E5.B (bon de commande, fiche technique, organisation dans le temps, hygiène) et du BTS blanc CNED E5B (adaptation d'une recette et calcul nutritionnel).

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Le centre social « La Passerelle » de Montclar (structure fictive) organise des ateliers sociolinguistiques (ASL) : des adultes arrivés en France depuis quelques mois ou quelques années y apprennent le français à partir de situations de la vie quotidienne (faire ses courses, aller chez le médecin, inscrire un enfant à l'école). La formatrice bénévole constate que le thème « alimentation » motive beaucoup le groupe : « Ils savent tous cuisiner, souvent très bien, mais ils sont perdus devant les étiquettes et les conseils qu'on leur donne à la PMI. » Elle vous demande de concevoir et d'animer un atelier culinaire qui serve à la fois à **apprendre des mots et des gestes en français** et à **découvrir des repères nutritionnels** utiles à toute la famille, à partir d'un menu simple et économique.

Document 1 – Le public et les contraintes

- 8 apprenants de 24 à 63 ans (6 femmes, 2 hommes) ; niveau de français oral A1 à A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues ; langues parlées : arabe (3), tamoul (2), dari (1), soninké (1), portugais (1).
- Trois apprenants ne lisent pas l'alphabet latin : une femme lit l'arabe, un homme lit le tamoul, une femme n'a jamais été scolarisée.
- Madame A. est enceinte de cinq mois ; Madame N. a un diabète de type 2 traité par comprimés ; Monsieur H. est végétarien ; cinq apprenants ne mangent pas de porc ; personne ne signale d'allergie.
- Cuisine du centre social : 4 plaques à induction, 1 four, 1 four à micro-ondes, 4 postes de travail pour 2 personnes, 1 réfrigérateur ; la formatrice est présente pendant tout l'atelier.
- Budget denrées : au plus 2,00 € par portion ; on prévoit 10 portions (8 apprenants, la formatrice et vous).
- Durée de l'atelier avec le public : 2 h 15, de 9 h 15 à 11 h 30, dégustation comprise. Le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 2 – Menu imposé

Plat : pois chiches mijotés aux épinards et à la tomate, riz complet.

Dessert : salade d'oranges à la cannelle, yaourt nature.

Le candidat réalise le plat et la salade d'oranges. Il présente aussi les adaptations pour Madame A. (grossesse) et pour Madame N. (diabète de type 2), et une version « à refaire à la maison » avec deux plaques et des produits de base.

Document 3 – Grammages nets par portion, pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Pois chiches en conserve, poids égoutté (boîte de 265 g égouttés)	120 g	sans perte	2,20 € le kg égoutté

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Épinards en branches surgelés (sachet de 1 kg)	100 g	sans perte	2,60 € le kg
Tomates pelées en conserve, égouttées	80 g	sans perte	1,60 € le kg
Oignons	30 g	10 %	1,80 € le kg
Huile d'olive vierge extra	6 g	sans perte	8,50 € le kg
Riz complet	60 g (cru)	sans perte	2,90 € le kg
Oranges	150 g	30 %	2,20 € le kg
Yaourt nature (pot de 125 g)	1 pot	sans perte	0,22 € le pot
Ail, cumin, curcuma, cannelle, citron, sel, poivre	–	–	forfait 0,80 € pour l'atelier

Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte).

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Pois chiche, appertisé, égoutté	122	6,74	15	0,5	2,68	5,45	0,54	1,15	0,1
Epinard, haché ou purée ou en branches, surgelé, cru	28	3,32	1	0,83	0,54	2,95	0,14	1,89	15,3
Tomate, pelée, appertisée, égouttée	16,4	0,9	1,61	1,6	0,28	1,27	0,33	0,57	12,6
Oignon, cru	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098	traces	3,9
Huile d'olive vierge extra	899	0,25	traces	0	99,9	0	< 0,013	< 0,05	0
Riz complet, cru	350	7,02	71,4	0	2,8	5	0,01	< 1	0
Orange, chair sans peau, sans pépins, crue	42	0,75	8,03	7,6	< 0,5	2,7	< 0,013	0,57	47,5
Yaourt ou lait fermenté, nature	50,1	3,83	4,26	4	1,68	traces	0,1	< 0,25	< 2

On calcule avec les poids nets (crus pour le riz, égouttés pour les conserves). Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 5 – La fiche recette utilisée jusqu'ici par le centre social (extrait)

« Émincer finement les oignons et l'ail, puis les faire revenir dans l'huile d'olive jusqu'à coloration légère avant d'incorporer les épices, qui seront torréfiées quelques instants afin de développer leurs arômes. Ajouter les tomates concassées, laisser compoter, puis incorporer les épinards préalablement décongelés et les pois chiches égouttés et rincés… » La fiche complète compte 150 mots, 6 phrases et 255 syllabes ; elle ne

comporte aucune image ; les quantités sont indiquées en grammes pour 10 personnes.

Document 6 – Repères utiles (données réelles)

- Le Cadre européen commun de référence pour les langues (Conseil de l'Europe, 2001) décrit six niveaux, de A1 (utilisateur élémentaire, découverte) à C2 ; au niveau A1, une personne comprend des expressions familières et quotidiennes et des énoncés très simples.
- Les règles européennes du « Facile à lire et à comprendre » (Inclusion Europe, 2009) et le guide « Communiquer pour tous » (Santé publique France, 2018) recommandent des phrases courtes, des mots courants, une idée par phrase et des images qui disent la même chose que le texte.
- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : des légumes secs au moins deux fois par semaine ; des féculents complets au moins une fois par jour ; au moins cinq fruits et légumes par jour.
- Pendant la grossesse, les recommandations officielles conseillent notamment d'éviter les fromages au lait cru, les produits de la mer crus et la charcuterie à la coupe (prévention de la listériose et de la toxoplasmose), et de laver soigneusement les légumes et les fruits.
- Le règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) impose d'informer les consommateurs sur la présence de 14 allergènes, y compris dans les denrées non préemballées.
- Indice de lisibilité de Kandel et Moles : L = 207 − 1,015 × (mots / phrases) − 73,6 × (syllabes / mots).

Travail à faire

Partie 1 – Conception (11 points)

1. Identifiez les besoins et les ressources de ce public (savoir-faire culinaires, langues, lecture, numératie, situations de santé) et formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier, dont au moins un objectif de langue. (2 pts)
2. Établissez le bon de commande pour 10 portions (quantités nettes, quantités brutes, unités de commande, coût) ; calculez le coût par portion et vérifiez le respect du budget. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique du plat (ingrédients, matériel, étapes, points critiques). Calculez l'indice de lisibilité de la fiche du document 5 ; rédigez une fiche recette « facile à lire » en six étapes illustrées au plus, indiquez ce que montre chaque image, et vérifiez sa lisibilité si elle compte 84 mots, 14 phrases et 118 syllabes. Présentez les adaptations demandées et la version « à refaire à la maison ». (3 pts)
4. Calculez l'apport d'une portion du repas (plat, salade d'oranges et yaourt) en énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, fer et vitamine C, et la répartition de l'énergie ; commentez au regard des repères, en particulier pour Madame A. (2 pts)
5. Expliquez, avec les notions du chapitre (littératie fonctionnelle, interactive et critique, littératie alimentaire, numératie, précautions universelles), comment l'atelier développe à la fois le français et les compétences alimentaires, et pourquoi il ne faut pas confondre maîtrise du français et compétences culinaires. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et participants), en organisant les binômes (langues, lecture) et les temps de langage. (2 pts)
7. Présentez les méthodes d'animation et les outils (imagier des ingrédients et des gestes, objets réels, démonstration, « faire dire »), ainsi qu'une grille de dégustation utilisable sans lecture. (1,5 pt)
8. Présentez les règles d'hygiène (5 M, lavage des fruits, conserves, riz cuit), la gestion des allergènes et les précautions pour Madame A., et trois éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

9. Réalisez le plat et la salade d'oranges ; dressez une assiette et un bol de dessert. (3 pts)
10. Proposez l'évaluation de l'atelier (satisfaction, mots appris, gestes et repères retenus, intention de refaire), sans recours à l'écrit pour les participants. (1 pt)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Voir avec les mains » : alimentation, information et autonomie de personnes déficientes visuelles

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet de synthèse – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2)

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Temps 1 : préparation conseillée 3 h, puis 30 min d'oral blanc · Temps 2 : 3 h · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique à l'association « Regards partagés » de Valbonne-sur-Lize (structure fictive), qui accompagne 120 adhérents adultes aveugles ou malvoyants. Le président, lui-même malvoyant, vous explique : « Nous ne pouvons pas lire les dates, les prix, les tableaux nutritionnels. Beaucoup d'entre nous mangent des plats tout prêts, parce qu'ils ont peur de se brûler ou de se couper. Et les campagnes de santé, avec leurs affiches et leurs sites, ne sont pas faites pour nous. » L'association souhaite un projet « Bien manger en autonomie », comprenant un atelier culinaire adapté. Vous devez analyser la situation, concevoir le projet et animer un premier atelier.

Temps 1 – Le projet d'intervention

Document 1 – Le public, la structure et les moyens

- 120 adhérents de 22 à 88 ans ; environ un tiers sont aveugles, deux tiers malvoyants (basse vision : lecture impossible ou très lente sans aide) ; 58 % vivent seuls.
- Outils utilisés par une partie des adhérents : lecteur d'écran sur smartphone, assistant vocal, loupe électronique, application de reconnaissance de texte ; quelques adhérents lisent le braille.
- Local : une cuisine pédagogique de 4 postes, plaques à induction, four à hauteur, contrastes de couleurs sur les plans de travail ; deux bénévoles formés à l'accompagnement.
- Partenaires : centre de rééducation basse vision (ergothérapeute, instructrice en autonomie dans la vie journalière), supermarché voisin, centre communal d'action sociale.
- Budget : 2 000 € pour l'année (hors salaires).

Document 2 – Enquête téléphonique auprès des adhérents (données fictives)

45 adhérents ont répondu à un questionnaire par téléphone (passation orale, 15 minutes).

Question	Réponses « oui » (n = 45)
Je ne peux pas lire les dates (DLC, DDM) sur les emballages	35
Je ne peux pas lire le tableau nutritionnel	39
J'utilise une application ou un assistant vocal pour lire les étiquettes	17
Je cuisine seul au moins 4 fois par semaine	28
Je me suis brûlé ou j'ai eu très peur de me brûler en cuisinant cette année	20
Je mange surtout des plats préparés	19
Je suis satisfait de mon alimentation	22

Croisement : parmi les 28 adhérents qui cuisinent seuls au moins 4 fois par semaine, 16 se sont brûlés ou ont eu très peur de se brûler ; parmi les 17 autres, 4.

Document 3 – Trois supports de prévention examinés (données fictives)

Support	Taille de police	Couleur du texte / du fond	Luminance relative du texte	Luminance relative du fond
A – Dépliant municipal « Manger mieux »	9 points	gris moyen sur blanc	0,216	1,000
B – Affiche d'un supermarché « Nos produits santé »	12 points	jaune pâle sur blanc	0,927	1,000
C – Fiche de l'association	16 points	noir sur blanc	0,000	1,000

Rapport de contraste selon les règles WCAG : (L1 + 0,05) / (L2 + 0,05), où L1 est la luminance relative la plus claire et L2 la plus foncée. Seuil minimal (niveau AA) : 4,5 pour un texte courant, 3 pour un grand texte (18 points, ou 14 points en gras).

Audit du site internet de la mairie, page « Santé » : 5 critères d'accessibilité sur 12 sont respectés (les images n'ont pas de texte alternatif, la vidéo n'est pas sous-titrée ni audiodécrite, les liens « cliquez ici » ne disent pas où ils mènent).

Document 4 – Paroles d'adhérents

« Au magasin, je demande au caissier de me lire la date. Il est pressé, alors je n'ose plus. » (Mme G., 67 ans, malvoyante)

« Mon téléphone me lit l'étiquette, mais il me lit tout, même la publicité ; je m'y perds. » (M. T., 34 ans, aveugle)

« Je faisais très bien la cuisine. Depuis que je ne vois plus, je réchauffe des barquettes. » (Mme L., 79 ans)

« Les dépliants de la mairie, je les jette, je ne peux pas les lire. » (M. B., 58 ans)

« Ce qu'il me faudrait, c'est qu'on me montre, avec les mains. » (Mme R., 46 ans)

Document 5 – Deux situations rencontrées pendant le stage

Une entreprise propose de financer l'atelier si l'association recommande son application payante de lecture d'étiquettes dans sa lettre d'information. Un bénévole souhaite filmer l'atelier et diffuser la vidéo sur la page publique de l'association « pour montrer que c'est possible ».

Document 6 – Cadre et repères (données réelles)

- La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées pose le principe d'accessibilité, y compris des services de communication en ligne des organismes publics (article 47).
- Le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA) s'appuie sur les règles internationales WCAG (W3C) ; la version 2.1 des WCAG date de 2018.
- La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (2006), ratifiée par la France en 2010, reconnaît le droit à l'accès à l'information.
- La directive européenne 2019/882 sur les exigences d'accessibilité des produits et services (« Acte européen sur l'accessibilité ») s'applique depuis le 28 juin 2025 à certains produits et services, dont le commerce électronique.

Travail à faire – temps 1

1. Calculez les indicateurs du document 2 et le taux de participation ; posez le diagnostic en distinguant ce qui relève des personnes, des produits (étiquetage) et de l'environnement (supports, magasins, sites). (2,5 pts)

2. Calculez le rapport de contraste des trois supports et le taux de conformité du site ; concluez sur leur accessibilité et proposez les corrections. Expliquez pourquoi une « bonne » lisibilité au sens de l'indice de Kandel et Moles ne suffit pas pour ce public. (2,5 pts)
3. Analysez la situation avec les notions du chapitre : dimensions de Sørensen, littératie alimentaire, littératie numérique et outils d'aide, littératie organisationnelle, précautions universelles. (2 pts)
4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et des objectifs opérationnels avec indicateurs ; présentez un plan d'action sur un an et un budget qui respecte les 2 000 €. (4 pts)
5. Calculez le risque relatif de brûlure ou de peur de se brûler selon la fréquence de cuisine solitaire et son intervalle de confiance à 95 % (même formule que dans les autres sujets). Concluez avec prudence. Calculez l'intervalle de confiance de la proportion d'adhérents qui ne peuvent pas lire le tableau nutritionnel, et la taille d'échantillon nécessaire pour une précision de ± 5 points (population de 120). (3 pts)
6. Organisez une veille sur l'accessibilité de l'information alimentaire et sur la déficience visuelle (sources, outils, fréquence). (2 pts)
7. Analysez les deux situations du document 5 et rédigez vos réponses ; indiquez comment rendre accessibles votre exposé et vos supports. (2 pts)

Qualité de l'expression, vocabulaire et sources datées : 2 pts.

Temps 2 – L'atelier culinaire « Cuisiner en sécurité, sans voir ou en voyant peu »

Document 7 – Le groupe et les contraintes

- 6 adhérents de 34 à 79 ans : 2 aveugles, 4 malvoyants ; Mme L. (79 ans) a un diabète de type 2 ; M. B. (58 ans) a une hypertension artérielle ; personne ne signale d'allergie.
- 2 bénévoles formés et l'ergothérapeute du centre de rééducation sont présents ; 4 postes de travail.
- Budget denrées : au plus 2,50 € par portion ; 10 portions (6 adhérents, 2 bénévoles, l'ergothérapeute et vous).
- Durée avec le public : 2 h 30, repas compris.

Document 8 – Menu imposé et grammages (données construites pour le sujet)

Plat : poulet mariné au yaourt et au citron, cuit au four ; semoule ; carottes râpées au jus d'orange. Dessert : banane écrasée au fromage blanc et à la cannelle.

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Filet de poulet sans peau	100 g	sans perte	11,50 € le kg
Yaourt nature (marinade)	30 g	sans perte	2,20 € le kg
Citron (jus)	5 g de jus	60 %	3,00 € le kg
Huile de colza	5 g	sans perte	3,20 € le kg
Semoule de blé dur	60 g (crue)	sans perte	1,90 € le kg
Carottes	100 g	15 %	1,40 € le kg
Oranges à jus (jus)	30 g de jus	55 %	2,00 € le kg
Bananes	80 g	35 %	2,00 € le kg
Fromage blanc nature 2-3 % MG	100 g	sans perte	2,60 € le kg
Ail, cumin, cannelle, persil, sel, poivre	–	–	forfait 0,90 € pour l'atelier

Document 9 – Extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Poulet, filet sans peau cru	110	23,4	0	traces	1,5	0	0,11

Aliment (libellé Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Yaourt ou lait fermenté, nature	50,1	3,83	4,26	4	1,68	traces	0,1
Jus de citron, pur jus	29,4	0,4	6,1	2,4	0,29	0,4	0,053
Huile de colza	900	0	0	0	100	0	< 0,0028
Semoule de blé dur, crue	350	11,8	69,8	1	1,28	3,7	0,0025
Carotte, crue	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12
Jus d'orange, pur jus	45,4	0,61	9,61	9,61	0,11	0,28	0,012
Banane, chair sans peau, crue	87,6	1,06	19,7	15,6	< 0,5	2,7	< 0,013
Fromage blanc, nature, 2-3% MG	75,7	7,28	3,86	3,86	3,23	0,019	0,088

Travail à faire – temps 2

8. Identifiez les besoins du groupe et formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier. (2 pts)

9. Établissez le bon de commande pour 10 portions et le coût par portion ; vérifiez le budget. Calculez l'apport d'une portion du repas et la répartition de l'énergie ; commentez pour Mme L. et M. B. (4 pts)

10. Rédigez la fiche technique du plat et une version accessible de la recette (audio, gros caractères à fort contraste, repères tactiles) ; présentez les adaptations du poste de travail et des gestes (couper, râper, verser un liquide chaud, utiliser le four) proposées avec l'ergothérapeute. (4 pts)

11. Présentez le déroulé minuté des 3 heures, les méthodes d'animation (guidage verbal précis, main sur main avec accord, repères « en horloge » dans l'assiette, « faire dire » et « faire faire ») et une grille de dégustation orale. (4 pts)

12. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité (volaille crue, cuisson à cœur, rangement constant des ustensiles, brûlures et coupures), la gestion des allergènes et trois éco-gestes. (3 pts)

13. Réalisez le plat et le dessert ; proposez l'évaluation de l'atelier (autonomie, sécurité, plaisir, intention de refaire). (3 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Les papiers, c'est ma fille qui les lit » : littératie en santé sur deux aires d'accueil des gens du voyage

que le jury attend

Le jury évalue la capacité à décrire des difficultés de littératie sans juger les personnes, à repérer aussi leurs **ressources** (oral, entraide, smartphone, confiance dans la médiatrice), et à proposer des actions qui changent d'abord les **supports** et l'**organisation** plutôt que les personnes. Il valorise les calculs exacts et interprétés, l'usage juste des notions (Sørensen, Nutbeam, numératie, illectronisme, précautions universelles, littératie organisationnelle) et le respect strict du secret professionnel. Il pénalise les jugements culturels (« ils ne s'intéressent pas à leur santé »), la confusion entre littératie et intelligence, et toute action qui désigne ou fiche des familles.

Partie A – Le projet d'intervention

Question 1 – Indicateurs, modèle de Sørensen et diagnostic (2 pts)

Calcul posé – Indicateurs du questionnaire oral (n = 74)

- Comprendre la notice d'un médicament : 41 / 74 × 100 = **55,4 %** trouvent cela difficile.
- Remplir un formulaire administratif : 52 / 74 × 100 = **70,3 %**.
- Trouver une information de santé sur internet : 49 / 74 × 100 = **66,2 %**.
- Juger la fiabilité d'une information de santé vue dans les médias : 44 / 74 × 100 = **59,5 %**.
- Comprendre ce que dit le médecin : 18 / 74 × 100 = **24,3 %**.
- Comprendre les informations sur les emballages : 46 / 74 × 100 = **62,2 %**.
- Possède un smartphone : 68 / 74 × 100 = **91,9 %** ; sait utiliser une application de santé : 15 / 74 × 100 = **20,3 %** ; lit le français couramment : 30 / 74 × 100 = **40,5 %**.
- Parmi les possesseurs de smartphone, utilisateurs d'une application de santé : 15 / 68 × 100 = **22,1 %**.
- Niveaux : insuffisant 26 / 74 = **35,1 %** ; problématique 28 / 74 = **37,8 %** ; suffisant 20 / 74 = **27,0 %**. Littératie limitée : (26 + 28) / 74 × 100 = **73,0 %**, contre environ **44 %** en population générale (HLS19, 2021), soit 73,0 / 44 ≈ **1,7 fois** plus.
- Taux de participation : 74 / 140 × 100 = **52,9 %** des adultes.

Question	Compétence (Sørensen, 2012)	Domaine
Comprendre la notice d'un médicament	Comprendre	Soins
Remplir un formulaire administratif	Appliquer (agir, communiquer une information)	Soins et accès aux droits
Trouver une information sur internet	Accéder	Prévention, promotion de la santé
Juger la fiabilité d'une information des médias	Évaluer	Promotion de la santé
Comprendre le médecin	Comprendre	Soins
Comprendre les emballages	Comprendre et appliquer	Prévention (alimentation)

Diagnostic. Près des trois quarts des adultes interrogés (73,0 %) ont une littératie en santé limitée, une proportion bien supérieure à la moyenne nationale. Les difficultés portent surtout sur l'**écrit** (formulaires 70,3 %, notices 55,4 %, emballages 62,2 %) et sur le **numérique** (internet 66,2 % ; seulement 20,3 % savent utiliser une application de santé, alors que 91,9 % ont un smartphone). L'**évaluation** de l'information est difficile pour 59,5 %

: c'est la compétence la plus exigeante, et elle explique des croyances comme « le jus, c'est des fruits » (Mme D.). À l'inverse, l'**oral** fonctionne mieux : seuls 24,3 % ont du mal à comprendre le médecin, et les familles regardent volontiers des vidéos (Mme S.). Les ressources sont réelles : l'entraide familiale (même si faire lire les papiers par une enfant de 12 ans pose problème), la confiance dans la médiatrice, l'usage quotidien du smartphone pour la vidéo et la messagerie.

Type de besoin (Bradshaw, 1972)	Dans la situation
Normatif	Caries fréquentes chez les enfants, consommation quotidienne de boissons sucrées (repères de l'OMS, 2015) ; littératie limitée bien au-dessus de la moyenne nationale
Ressenti	« Le docteur parle vite » ; peur ou gêne dans les bureaux ; douleur dentaire de l'enfant
Exprimé	Préférence pour la vidéo et pour la venue de la médiatrice sur l'aire
Comparatif	73,0 % de littératie limitée contre environ 44 % en France

Question 2 – Lisibilité et test de compréhension (2 pts)

Calcul posé – Indice de Kandel et Moles et test auprès de 20 mères

- Version actuelle : mots par phrase 180 / 7 = **25,71** ; syllabes par mot 324 / 180 = **1,80**. L = 207 − 1,015 × 25,71 − 73,6 × 1,80 = 207 − 26,10 − 132,48 = **48,42** : texte **difficile**.
- Version réécrite : mots par phrase 90 / 13 = **6,92** ; syllabes par mot 130 / 90 = **1,44**. L = 207 − 1,015 × 6,92 − 73,6 × 1,444 = 207 − 7,03 − 106,31 = **93,66** : texte **très facile**.
- Gain : 93,66 − 48,42 = **45,24 points**.
- Test : bonnes réponses 6 / 20 × 100 = **30 %** avec la version actuelle ; 16 / 20 × 100 = **80 %** avec la version réécrite, soit **+ 50 points**.

Interprétation. La réécriture fait passer le texte de « difficile » à « très facile » et multiplie par 80 / 30 ≈ **2,7** la proportion de bonnes réponses. Les deux mesures sont complémentaires. L'indice de lisibilité mesure seulement la **longueur** des phrases et des mots : il ne dit rien du sens, des sigles, de la taille de la police, des images, ni de la culture du public, et il ne s'applique pas à une personne qui ne lit pas. Le **test de compréhension** auprès de personnes du public mesure ce qui compte vraiment (le message est-il compris ?), mais sur un petit effectif (20 mères) et avec une seule question. Pour ce public, où 59,5 % des adultes ne lisent pas couramment le français, un dépliant même très lisible restera insuffisant : il doit être accompagné d'une **explication orale** et d'un **support visuel ou vidéo**.

Question 3 – Analyse avec les notions du chapitre (2 pts)

- **Niveaux de Nutbeam** : la littératie **fonctionnelle** (lire une notice, une étiquette) est limitée pour une majorité ; la littératie **interactive** est une force (échanger avec la médiatrice, demander à la pharmacienne) ; la littératie **critique** (juger la publicité « 100 % fruits ») est à développer, en groupe.
- **Littératie alimentaire** (Vidgen et Gallegos, 2014) : les compétences de **préparation** et de **partage** sont présentes ; la **sélection** (lire les emballages, repérer le sucre) est difficile.
- **Numératie** : les grammes de sucre pour 100 mL ne parlent pas ; les morceaux de sucre et les verres, oui.
- **Illectronisme** : avoir un smartphone ne suffit pas (20,3 % savent utiliser une application de santé) ; la dématérialisation des démarches (Mon espace santé, prise de rendez-vous) **exclut** une partie des familles.
- **Littératie organisationnelle** : les documents de la PMI, les formulaires et les bureaux ne sont pas adaptés ; la mobilité (départ au printemps) rompt le suivi ; la responsabilité est d'abord celle des institutions (« nos documents ne servent à rien »).
- **Inégalités sociales de santé** : faible scolarisation, conditions de vie sur les aires, discriminations et méfiance envers les institutions ; une communication écrite standard **creuse le gradient** (chapitre 2) ; l'**universalisme proportionné** justifie des moyens renforcés (médiation, oral, venue sur l'aire).

- **Enfant interprète** : faire lire les papiers par une enfant de 12 ans inverse les rôles et expose à des erreurs ; il faut proposer d'autres solutions (médiatrice, lecture à voix haute, interprétariat si besoin).

Problème central : les messages de santé bucco-dentaire et alimentaire destinés aux familles des aires d'accueil sont peu compris et peu utilisables, parce qu'ils reposent sur l'écrit et le numérique. Causes : supports écrits complexes, démarches en ligne, faible scolarisation, méfiance envers les institutions, publicité trompeuse, mobilité. Conséquences : consommation quotidienne de boissons sucrées, caries non soignées, douleurs, recours tardif aux soins, mauvaise compréhension des traitements chez les adultes diabétiques.

Question 4 – Objectifs (1,5 pt)

Objectif général : améliorer la santé bucco-dentaire et nutritionnelle des enfants des aires d'accueil du Val de Sorne en rendant les informations de santé accessibles et utilisables par les familles, d'ici un an.

Objectif	Indicateur	Valeur de départ	Cible	Échéance
Spécifique 1 : réduire la consommation quotidienne de boissons sucrées des enfants de 3 à 11 ans	Part des enfants qui boivent des boissons sucrées tous les jours (déclaration des parents)	34 / 60 = 56,7 %	40 %	12 mois
Spécifique 2 : rendre les supports et les démarches de santé compréhensibles par les familles	Part de bonnes réponses aux tests de compréhension des supports	30 %	80 % au moins pour chaque support	6 mois
Opérationnel 1 : produire avec 6 mères trois vidéos de 2 minutes (boissons, brossage des dents, rendez-vous dentaire), diffusées par messagerie	Nombre de vidéos produites et nombre de familles destinataires	0	3 vidéos, 40 familles	4 mois
Opérationnel 2 : animer 6 ateliers « boissons et goûters » sur l'aire, avec morceaux de sucre et dégustation d'eaux aromatisées maison	Nombre d'ateliers et de participants ; « faire dire » réussi	0	6 ateliers, 30 participants, 80 % de « faire dire » réussis	Avant le départ d'avril
Opérationnel 3 : réécrire et tester les 4 documents de la PMI les plus utilisés	Indice de lisibilité et test de compréhension	L ≈ 48 ; 30 %	L ≥ 80 ; 80 % de bonnes réponses	3 mois
Opérationnel 4 : accompagner 20 familles dans la prise d'un rendez-vous dentaire avant le départ du printemps	Nombre de rendez-vous honorés	–	20	Mars

Question 5 – Plan d'action et budget (1,5 pt)

Période	Action	Notion justifiant l'action
Novembre-décembre	Formation courte des médiatrices et des professionnels de la PMI à l'écriture claire et au « faire dire » ; réécriture et test des documents	Littératie organisationnelle ; précautions universelles
Décembre-février	Tournage des vidéos avec les mères volontaires (elles choisissent les mots et les images)	Participation ; littératie interactive ; canal adapté (vidéo, messagerie)
Janvier-mars	Six ateliers « boissons et goûters » sur l'aire : morceaux de sucre, verres d'eau aromatisée, comparaison de briques de jus	Numératie (morceaux de sucre) ; littératie critique (« 100 % fruits » ne veut pas dire « sans sucre »)

Période	Action	Notion justifiant l'action
Février-mars	Rendez-vous dentaires accompagnés, avant le départ ; remise d'un carnet de santé enfant avec rappel illustré	Accès aux soins ; continuité malgré la mobilité
Avril-octobre	Pendant les voyages : rappels vidéo et vocaux par messagerie ; lien avec les associations des autres départements	Mobilité ; universalisme proportionné
Novembre suivant	Évaluation au retour des familles ; restitution collective sur l'aire	Évaluation participative

Poste	Coût
Réalisation et montage de 3 vidéos (location de matériel, sous-titrage)	350 €
Impression de supports illustrés et plastifiés (pictogrammes, calendrier de brossage)	200 €
Denrées pour 6 ateliers (60 € par atelier)	360 €
Matériel pédagogique (verres doseurs, morceaux de sucre, carafes, gobelets)	120 €
Kits de brossage (60 kits à 3 €)	180 €
Bons d'achat pour les mères relais (participation à la conception)	300 €
Jeux et outils pédagogiques (pédagothèque, imagiers)	150 €
Déplacements	140 €
Total	**1 800 €**

Vérification : 350 + 200 + 360 + 120 + 180 + 300 + 150 + 140 = **1 800 €** ✓.

Partie B – Recherche appliquée

Question 6 – Prévalence, risque relatif et intervalle de confiance (1,5 pt)

Calcul posé – Caries et boissons sucrées (n = 60)

Notations : a = 21 (boissons quotidiennes et carie), a + b = 34 ; c = 6 (sans boissons quotidiennes et carie), c + d = 26.

- Prévalence des caries non soignées : (21 + 6) / 60 × 100 = **45,0 %**.
- Risque chez les exposés : 21 / 34 = **61,8 %** ; chez les non-exposés : 6 / 26 = **23,1 %**.
- RR = 0,618 / 0,231 = **2,68**.
- ln RR = ln 2,68 = 0,984 ; erreur type = √(1/21 − 1/34 + 1/6 − 1/26) = √(0,0476 − 0,0294 + 0,1667 − 0,0385) = √0,1464 = **0,383**.
- IC 95 % = exp(0,984 ± 1,96 × 0,383) = exp(0,984 ± 0,750) = [exp(0,234) ; exp(1,734)] = **[1,26 ; 5,67]**.

Interprétation. Les enfants qui boivent des boissons sucrées tous les jours ont 2,7 fois plus souvent une carie non soignée que les autres ; l'intervalle de confiance ne contient pas 1 : l'association est **statistiquement significative** au seuil de 5 %. On ne peut pas conclure à une relation de cause à effet : l'étude est **transversale** (exposition et carie mesurées au même moment) ; d'autres facteurs peuvent intervenir (**brossage**, dentifrice fluoré, sucreries, accès au dentiste, âge de l'enfant), qui ne sont pas pris en compte ; la consommation est **déclarée** par les parents (biais de mémoire et de désirabilité) ; l'effectif est petit (intervalle large). La relation est cependant plausible et cohérente avec les connaissances (OMS, 2015) : elle justifie l'action.

Question 7 – Intervalle de confiance, taille d'échantillon et limites (1,5 pt)

Calcul posé – Proportion de littératie limitée

- p = 54 / 74 = **0,730**.

- Demi-largeur : 1,96 × √(0,730 × 0,270 / 74) = 1,96 × √0,002663 = 1,96 × 0,0516 = **0,101**.
- IC 95 % = 0,730 ± 0,101 = **[62,9 % ; 83,1 %]**.
- Taille d'échantillon pour ± 5 points : n0 = 1,96² × 0,730 × 0,270 / 0,05² = 3,8416 × 0,1971 / 0,0025 = **303** ; correction pour une population de 140 : n = 303 / (1 + (303 − 1) / 140) = 303 / 3,157 = **96** adultes.

Avec 74 répondants, la précision est d'environ ± 10 points ; il faudrait interroger 96 des 140 adultes pour atteindre ± 5 points. Mais même la borne basse de l'intervalle (62,9 %) reste bien au-dessus de la moyenne nationale : la conclusion du diagnostic ne change pas.

Limites d'un questionnaire administré par les médiatrices : **désirabilité sociale** (répondre ce qui plaît à une personne connue, ou au contraire minimiser ses difficultés par fierté) ; **biais de sélection** (volontaires, familles présentes en hiver, plus proches de l'association) ; **reformulation** variable des questions d'un entretien à l'autre (biais d'enquêteur) ; méthode de score **simplifiée**, non validée, qui ne permet qu'une comparaison prudente avec HLS19.

Partie C – Veille

Question 8 – Organiser la veille (2 pts)

Thème	Sources fiables	Outils	Fréquence
Littératie en santé	Santé publique France (« Communiquer pour tous », dossiers littératie) ; réseau M-POHL de l'OMS Europe (HLS19 et cycle suivant) ; HAS (fiche « Faire dire », 2015 ; référentiel de médiation, 2017)	Alertes sur les sites, lettres d'information	Mensuelle
Santé des gens du voyage	Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes et les gens du voyage (FNASAT) ; ARS (programmes régionaux pour l'accès à la prévention et aux soins des plus démunis, PRAPS) ; Défenseur des droits	Lettres d'information, rapports annuels	Trimestrielle
Santé bucco-dentaire et sucres	OMS ; Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD) ; Assurance maladie (examen bucco-dentaire « M'T dents »)	Bases documentaires, alertes	Trimestrielle
Outils pédagogiques	Instances régionales d'éducation et de promotion de la santé (pédagothèques) ; SantéBD (FALC)	Catalogues en ligne	À chaque projet

Diffusion : une fiche de synthèse d'une page, datée, pour l'équipe et les médiatrices, et un point oral mensuel ; les sources sont classées par date et par fiabilité.

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique

Question 9 – Trois situations (1,5 pt)

- **Liste des familles « négligentes »** : les données de santé recueillies par le cabinet dentaire et par l'association sont couvertes par le **secret professionnel** ; aucune liste nominative n'est transmise à la mairie. La demande est en outre **stigmatisante** : une carie n'est pas une preuve de négligence (accès aux soins, mobilité, information inadaptée). Réponse : « Je ne peux pas vous transmettre d'information sur la santé des enfants. Je peux en revanche vous présenter des résultats anonymes et collectifs, et vous proposer de travailler avec nous sur l'accès au dentiste pour toutes les familles de l'aire. » Si un enfant est réellement en danger, la procédure relève de l'information préoccupante, par les professionnels compétents, pas d'une liste.

- **Tablettes contre données** : les données d'utilisation d'une application de « coaching nutritionnel » sont des **données personnelles**, parfois de santé (RGPD) ; elles ne peuvent pas être une contrepartie commerciale. L'outil n'a pas été évalué, il est conçu pour l'écrit et risque de culpabiliser. Réponse : refus courtois ; un éventuel partenariat devrait être sans collecte de données, sans publicité, et validé par l'association.
- **Photos d'enfants pour un reportage « malbouffe »** : le **droit à l'image** des mineurs exige l'autorisation écrite des deux parents ; le titre envisagé est **stigmatisant** et risque de rompre la confiance des familles. Réponse : pas de photo pendant l'atelier ; proposition éventuelle d'un entretien avec l'association sur ce qui fonctionne (médiation, vidéos faites par les mères), avec l'accord des familles et sans enfants identifiables.

Question 10 – Supports adaptés, trame de l'exposé et questions du jury (1,5 pt)

Supports : vidéos courtes (2 minutes), tournées avec les mères, en français simple, sous-titrées et doublées par la voix de la médiatrice ; messages vocaux par messagerie ; affiches à pictogrammes dans le local ; objets réels (bouteilles, morceaux de sucre, verres) ; carnet illustré de rendez-vous. Pas de dépliant seul : tout support écrit est remis **avec** une explication orale et un « faire dire ».

Trame de l'exposé (10 minutes) : 1 min, contexte et demande ; 2 min, diagnostic chiffré (73,0 % de littératie limitée, lisibilité et test de compréhension, caries et boissons) ; 1 min 30, analyse (Sørensen, Nutbeam, illectronisme, littératie organisationnelle) ; 2 min, objectifs et plan d'action ; 1 min, ce que j'ai réalisé (réécriture testée, un atelier) ; 1 min 30, évaluation et limites ; 1 min, éthique et conclusion.

Questions probables du jury : 1. Qu'est-ce que la littératie en santé selon Sørensen ? 2. Pourquoi la littératie n'est-elle pas l'intelligence ? 3. Que sont les précautions universelles ? 4. Comment avez-vous évité de stigmatiser les familles ? 5. Pourquoi un dépliant très lisible ne suffit-il pas ? 6. Quelles limites a l'indice de Kandel et Moles ? 7. Comment avez-vous testé vos supports ? 8. Pourquoi la vidéo plutôt que l'écrit ? 9. Que pensez-vous des enfants qui lisent les papiers de leurs parents ? 10. Comment tenez-vous compte de la mobilité des familles ? 11. Votre RR prouve-t-il que les sodas causent les caries ? 12. Comment avez-vous travaillé avec les médiatrices ? 13. Comment protégez-vous les données recueillies ? 14. Qu'avez-vous répondu à la mairie ? 15. Comment évaluerez-vous l'action pendant les voyages ?

Barème – Barème du temps 1

Partie A : 9 points (indicateurs et diagnostic 2 ; lisibilité et test 2 ; analyse 2 ; objectifs 1,5 ; plan et budget 1,5). Partie B : 3 points. Partie C : 2 points. Partie D : 3 points. Expression, vocabulaire et sources datées : 3 points. Total : 20 points.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Confondre littératie limitée, illettrisme et illectronisme, ou additionner leurs pourcentages ; conclure que les familles « ne s'intéressent pas à leur santé » ; s'arrêter à l'indice de lisibilité sans test auprès du public ; proposer un dépliant ou un site internet comme seule solution ; oublier la mobilité des familles ; présenter le RR comme une preuve de causalité ; accepter de transmettre une liste nominative ou des photos d'enfants.

Corrigé S2 – « Cuisiner pour apprendre le français » : un atelier avec un groupe d'apprenants en ateliers sociolinguistiques

> **que le jury attend**
>
> Le jury évalue la capacité à concevoir un atelier qui part des **savoir-faire** des participants (ils savent cuisiner) et qui compense leurs difficultés d'**écrit** et de **langue** par l'image, l'objet, le geste et l'oral. Il valorise un bon de commande exact, une fiche recette réellement accessible (testable sans lecture), des calculs nutritionnels justes et commentés, la prise en compte de la grossesse et du diabète sans discours médicalisé, et une évaluation sans écrit. Il pénalise la confusion entre maîtrise du français et compétences culinaires, les consignes uniquement écrites et l'oubli des précautions d'hygiène.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Besoins, ressources et objectifs (2 pts)

Domaine	Besoins	Ressources
Langue et écrit	Niveau A1-A2 à l'oral ; trois apprenants ne lisent pas l'alphabet latin, dont une personne jamais scolarisée ; vocabulaire de la cuisine et des courses en français à acquérir	Langues maternelles variées ; entraide entre apprenants ; présence de la formatrice
Alimentation	Comprendre les étiquettes et les conseils de la PMI ; repères sur les légumes secs, les céréales complètes, les fruits	Savoir-faire culinaires souvent élevés ; plats familiaux à base de légumineuses (houmous, dal, chorba)
Numératie	Passer des grammes aux mesures courantes ; comprendre un prix au kilo	Habitude de gérer un budget serré
Santé	Grossesse (Mme A.) ; diabète de type 2 (Mme N.) ; végétarisme (M. H.) ; pas de porc pour cinq personnes	Le menu imposé convient à tous : végétarien et sans porc

Objectif général : permettre aux apprenants de cuisiner et de nommer en français un repas équilibré et économique à base de légumes secs, et de comprendre des repères nutritionnels utiles à leur famille.

Objectifs opérationnels (à la fin de l'atelier, chaque apprenant sera capable de) :

1. **Langue** : nommer en français, à l'oral, au moins 8 des 12 mots de l'imagier (pois chiches, épinards, oignon, riz complet, orange, yaourt, éplucher, couper, rincer, cuire, mélanger, goûter).
2. **Gestes** : réaliser en binôme une étape de la recette à partir de la fiche en images, sans aide écrite.
3. **Repères** : montrer, avec les objets, la portion de légumes secs d'un repas et dire pourquoi l'orange est servie avec le plat (vitamine C et fer), en « faire dire ».

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 10 portions

Denrée	Net par portion	Net pour 10	Perte	Brut pour 10	Unité de commande	Coût
Pois chiches égouttés	120 g	1 200 g	0 %	1 200 g	5 boîtes de 265 g égouttés (1 200 / 265 = 4,5)	1,200 × 2,20 = 2,64 €
Épinards surgelés	100 g	1 000 g	0 %	1 000 g	1 sachet de 1 kg	1,000 × 2,60 = 2,60 €
Tomates pelées égouttées	80 g	800 g	0 %	800 g	2 boîtes de 400 g égouttés	0,800 × 1,60 = 1,28 €
Oignons	30 g	300 g	10 %	300 / 0,90 = 333 g	0,350 kg	0,333 × 1,80 = 0,60 €

Denrée	Net par portion	Net pour 10	Perte	Brut pour 10	Unité de commande	Coût
Huile d'olive	6 g	60 g	0 %	60 g	Stock (bouteille entamée)	0,060 × 8,50 = 0,51 €
Riz complet	60 g	600 g	0 %	600 g	1 paquet de 1 kg	0,600 × 2,90 = 1,74 €
Oranges	150 g	1 500 g	30 %	1 500 / 0,70 = 2 143 g	2,2 kg (environ 9 oranges)	2,143 × 2,20 = 4,71 €
Yaourts nature	1 pot	10 pots	0 %	10 pots	10 pots de 125 g	10 × 0,22 = 2,20 €
Épices, ail, citron, sel	–	–	–	–	Forfait	0,80 €

Total : 2,64 + 2,60 + 1,28 + 0,60 + 0,51 + 1,74 + 4,71 + 2,20 + 0,80 = **17,08 €** ; coût par portion : 17,08 / 10 = **1,71 €**, inférieur au plafond de 2,00 € (marge de 2,92 € sur le budget de 20,00 €). Le coût est calculé sur les quantités utilisées ; la cinquième boîte de pois chiches entamée et le reste de riz restent au centre social. Remarque : les oranges représentent 4,71 / 17,08 × 100 = 27,6 % du coût ; en été, on les remplacerait par un fruit de saison moins cher.

Question 3 – Fiche technique, fiche « facile à lire », adaptations (3 pts)

Modèle – Fiche technique : pois chiches mijotés aux épinards et à la tomate, riz complet (10 portions)

Ingrédients : pois chiches égouttés 1 200 g ; épinards surgelés 1 000 g ; tomates pelées 800 g ; oignons 333 g bruts ; huile d'olive 60 g ; ail 2 gousses ; cumin 2 cuillères à café ; curcuma 1 cuillère à café ; jus d'un demi-citron ; sel, poivre ; riz complet 600 g.

Matériel : 2 faitouts, 1 casserole pour le riz, planches et couteaux d'office, passoire, cuillères en bois, balance, verre doseur, thermomètre à sonde.

Étapes : 1. Rincer le riz, le cuire 25 à 30 minutes dans 2,5 fois son volume d'eau bouillante. 2. Éplucher et émincer les oignons et l'ail ; les faire revenir 5 minutes dans l'huile. 3. Ajouter les épices, remuer 30 secondes. 4. Ajouter les tomates, cuire 5 minutes. 5. Ajouter les épinards encore surgelés, couvrir 8 à 10 minutes. 6. Ajouter les pois chiches rincés, mijoter 10 minutes ; ajouter le citron, goûter, saler peu. 7. Servir avec le riz.

Points critiques : lavage des mains et des plans de travail ; boîtes de conserve propres, bombées refusées ; maintien au chaud au-dessus de 63 °C jusqu'au service ; riz cuit refroidi en moins de 2 heures s'il est conservé (risque lié à *Bacillus cereus*) ; ustensiles coupants rangés à plat, pointe vers l'intérieur.

Calcul posé – Lisibilité de la fiche actuelle et de la fiche « facile à lire »

- Fiche actuelle : 150 / 6 = **25** mots par phrase ; 255 / 150 = **1,70** syllabe par mot ; L = 207 − 1,015 × 25 − 73,6 × 1,70 = 207 − 25,38 − 125,12 = **56,50** : « assez difficile ».
- Fiche réécrite : 84 / 14 = **6** mots par phrase ; 118 / 84 = **1,405** ; L = 207 − 1,015 × 6 − 73,6 × 1,405 = 207 − 6,09 − 103,40 = **97,51** : « très facile ».

La fiche réécrite remplace les verbes techniques (émincer, faire revenir, déglacer, compoter) par des verbes courants (couper, cuire, mélanger) et chaque étape par **une photo**. Mais l'indice ne vaut que pour les lecteurs : pour les trois apprenants qui ne lisent pas l'alphabet latin, ce sont les **images**, les **objets** et la **démonstration** qui portent le message.

Étape	Ce que montre la photo	Texte court (une phrase)
1	Mains sous le robinet, savon	Je lave mes mains.
2	Couteau qui coupe un oignon sur une planche	Je coupe l'oignon.
3	Oignon dans la casserole avec l'huile, cuillère en bois	Je cuis l'oignon avec l'huile.

Étape	Ce que montre la photo	Texte court (une phrase)
4	Tomates, puis épinards dans la casserole	J'ajoute les tomates et les épinards.
5	Pois chiches dans la passoire sous l'eau, puis dans la casserole	Je rince les pois chiches. Je mélange.
6	Assiette avec riz, pois chiches et une orange à côté	Je sers avec le riz. Je mange l'orange.

Les quantités sont données en **objets** (1 boîte, 1 sachet, 1 oignon, 1 verre de riz pour 2 personnes) ; chaque apprenant peut écrire ou faire écrire, à côté de chaque mot, le mot dans sa langue (lexique personnel).

Adaptations. **Mme A. (grossesse)** : le repas lui convient très bien (fer, vitamine C, fibres) ; laver les oranges avant de les éplucher ; yaourt pasteurisé du commerce (pas de fromage au lait cru au menu) ; cuire les épinards à cœur ; rappeler, sans dramatiser, les aliments à éviter (fromages au lait cru, charcuterie à la coupe, produits de la mer crus) avec des photos. **Mme N. (diabète de type 2)** : garder le riz complet et la portion de 60 g crus, ne pas ajouter de sucre à la salade d'oranges (la cannelle suffit), manger le fruit entier plutôt qu'un jus, servir l'orange à la fin du repas ; pas d'interdit. **Version « à refaire à la maison »** : deux plaques suffisent (une pour le riz, une pour le plat) ; pois chiches en conserve, épinards surgelés et tomates en boîte se gardent longtemps ; le plat se congèle en portions ; variante avec des lentilles corail ou des haricots rouges selon les habitudes de chacun.

Question 4 – Apports d'une portion et commentaire (2 pts)

Calcul posé – Apport d'une portion (poids nets, Ciqual 2025)

Aliment (quantité)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)	Vit. C (mg)
Pois chiches (120 g)	146,4	8,09	18,00	0,60	3,22	6,54	0,65	1,38	0,12
Épinards (100 g)	28,0	3,32	1,00	0,83	0,54	2,95	0,14	1,89	15,30
Tomates (80 g)	13,1	0,72	1,29	1,28	0,22	1,02	0,26	0,46	10,08
Oignon (30 g)	11,7	0,33	1,88	1,44	0,19	0,51	0,03	0	1,17
Huile d'olive (6 g)	53,9	0,01	0	0	5,99	0	0	0	0
Riz complet cru (60 g)	210,0	4,21	42,84	0	1,68	3,00	0,01	0	0
Orange (150 g)	63,0	1,12	12,04	11,40	0	4,05	0	0,85	71,25
Yaourt nature (125 g)	62,6	4,79	5,33	5,00	2,10	0	0,12	0	0
Total	**588,8**	**22,60**	**82,37**	**20,55**	**13,94**	**18,07**	**1,21**	**4,58**	**97,92**

Répartition de l'énergie : protéines 22,60 × 4 / 588,8 × 100 = **15,4 %** ; glucides 82,37 × 4 / 588,8 × 100 = **56,0 %** ; lipides 13,94 × 9 / 588,8 × 100 = **21,3 %** ; les fibres (2 kcal par gramme dans le calcul réglementaire) apportent 18,07 × 2 / 588,8 × 100 = **6,1 %**.

Commentaire. Le repas est rassasiant et économique (1,71 €), riche en **fibres** (18,1 g, soit plus de la moitié des 30 g conseillés par jour), pauvre en **sel** (1,2 g) et en lipides. Les sucres (20,6 g) viennent presque entièrement de l'orange, du yaourt et des légumes : il n'y a pas de sucre ajouté. Les protéines (22,6 g) associent légumineuses, céréale et produit laitier. Pour **Mme A.**, le repas apporte **4,6 mg de fer**, d'origine végétale (non héminique), mieux absorbé grâce aux **98 mg de vitamine C** de l'orange et des légumes servis au même repas ; les épinards et les pois chiches apportent aussi des folates (non chiffrés ici, car absents de l'extrait). Pour **Mme N.**, les glucides (82 g) sont surtout des glucides complexes accompagnés de beaucoup de fibres, ce qui limite l'élévation de la glycémie ; la portion de riz peut être adaptée avec elle.

Question 5 – Littératie, langue et compétences alimentaires (2 pts)

L'atelier développe la **littératie fonctionnelle** (reconnaître des mots, une boîte, une date sur un emballage, avec l'aide des images), la **littératie interactive** (demander, expliquer à son binôme, « faire dire ») et une première **littératie critique** (comparer deux conserves de pois chiches au prix au kilo, se demander si un produit « spécial santé » est utile). Il travaille plusieurs domaines de la **littératie alimentaire** (Vidgen et Gallegos, 2014) : **sélectionner** (lire une conserve), **préparer** (cuire des légumes secs, hygiène), **manger** (repères, partage) et **planifier** (une recette économique à refaire). La **numératie** est abordée par les mesures en objets (un verre, une boîte) et le coût par portion (1,71 €), mieux compris qu'un prix au kilo. Selon les **précautions universelles**, toutes les consignes sont données à l'oral, montrées et illustrées, pour tout le groupe, sans désigner ceux qui ne lisent pas.

Ne pas confondre maîtrise du français et compétences culinaires : ces apprenants savent souvent très bien cuisiner, gérer un budget et nourrir une famille ; leur difficulté porte sur la **langue** et l'**écrit**, pas sur l'alimentation. Les traiter comme des débutants en cuisine serait vexant et ferait perdre une ressource précieuse : on leur demande au contraire de montrer leurs gestes et de raconter leurs plats, ce qui crée du langage.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté des 3 heures (2 pts)

Horaire	Candidat	Participants
8 h 30 – 9 h 15	Mise en place : vérification des denrées et des températures, installation des 4 postes, imagier affiché, objets réels sur une table, riz rincé	–
9 h 15 – 9 h 30	Accueil, prénoms, présentation de l'atelier avec les objets (boîte de pois chiches, sachet d'épinards, orange) ; consignes d'hygiène montrées	Lavage des mains, tablier ; chacun dit comment il cuisine les pois chiches chez lui
9 h 30 – 9 h 45	Imagier : 12 mots et gestes, répétés à voix haute	Répètent, montrent l'objet, disent le mot dans leur langue
9 h 45 – 9 h 55	Démonstration lente : couper l'oignon, rincer les pois chiches	Regardent, un apprenant refait le geste
9 h 55 – 10 h 40	Circule entre les postes, reformule, montre ; lance la cuisson du riz	En binômes (un lecteur et un non-lecteur, langues différentes), réalisent le plat avec la fiche en images
10 h 40 – 10 h 55	Salade d'oranges : montre comment éplucher à vif	Épluchent et coupent les oranges, ajoutent la cannelle
10 h 55 – 11 h 15	Dégustation, grille à smileys, échanges sur les repères (légumes secs, orange et fer)	Goûtent, notent avec les smileys, racontent
11 h 15 – 11 h 30	« Faire dire » et évaluation : chaque binôme montre une étape et nomme 3 mots	Montrent, nomment ; reçoivent la fiche en images
11 h 30 – 11 h 45	Remise en état, plonge, tri des déchets	Participent selon leur envie

Question 7 – Méthodes, outils et grille de dégustation (1,5 pt)

Méthodes : démonstration avant l'action ; **apprentissage par le faire** ; répétition des mots en situation (« Je coupe l'oignon ») ; binômes mixtes ; **faire dire** et **faire montrer** plutôt que « Vous avez compris ? ». Outils : imagier de 12 photos (ingrédients et gestes) avec le mot écrit en grand ; objets réels (boîtes, sachets, verres doseurs, morceaux de sucre pour comparer un soda et l'orange) ; fiche recette en 6 photos ; prix par portion affiché en euros. Grille de dégustation sans lecture : pour chaque plat, trois smileys (j'aime, un peu, je n'aime pas) à entourer ou à montrer du doigt, et une question orale « Qu'est-ce que tu changerais ? » ; la formatrice note les réponses.

Question 8 – Hygiène, allergènes, grossesse, éco-gestes (1,5 pt)

Hygiène (méthode des 5 M) : **main-d'œuvre** (lavage des mains montré, cheveux attachés, tablier) ; **milieu** (plans de travail nettoyés et désinfectés) ; **matériel** (planches propres, couteaux rangés) ; **matière** (conserves non

bombées, rinçage des pois chiches, oranges lavées avant épluchage, épinards cuits à cœur) ; **méthode** (marche en avant, riz servi aussitôt ou refroidi rapidement). Allergènes : le yaourt contient du **lait** (affiché par un pictogramme) ; vérifier l'étiquette des épices et de la conserve de pois chiches (traces éventuelles) ; demander oralement à chacun s'il a une allergie. Grossesse : aucune préparation à risque au menu ; on en profite pour montrer les photos des aliments à éviter. Éco-gestes : produits secs et surgelés sans gaspillage, eau de rinçage des légumes réutilisée pour la plonge, épluchures d'orange et d'oignon au compost, cuisson couverte.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (3 pts)

Plat : oignons fondants non brûlés, épices torréfiées sans amertume, épinards bien cuits et égouttés, pois chiches entiers et chauds, assaisonnement mesuré ; riz complet tendre et égrené. Salade d'oranges : suprêmes ou rondelles sans peau blanche, cannelle légère. Dressage : assiette avec le riz d'un côté, les pois chiches de l'autre, un peu de persil ; bol d'oranges et yaourt à part.

Question 10 – Évaluation sans écrit (1 pt)

Satisfaction : smileys montrés du doigt. Mots appris : l'imagier présenté au début et à la fin (nombre de mots nommés sur 12) ; exemple de calcul si le groupe nomme en moyenne 36 mots au total au début (36 / 8 = 4,5 mots par personne, 37,5 %) et 75 à la fin (75 / 8 = 9,4 mots, 78,1 %). Gestes et repères : « faire montrer » une étape et « faire dire » pourquoi l'orange accompagne le plat. Intention de refaire : « Tu vas cuisiner ce plat chez toi ? » ; à la séance suivante d'ASL, la formatrice demande qui l'a refait.

Barème – Barème du sujet

Partie 1 : besoins et objectifs 2 ; bon de commande 2 ; fiche technique, fiche accessible, lisibilité et adaptations 3 ; apports 2 ; analyse 2. Partie 2 : déroulé 2 ; méthodes et outils 1,5 ; hygiène 1,5. Partie 3 : réalisation 3 ; évaluation 1. Total : 20 points.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Oublier les pertes des oranges et des oignons ; calculer le riz avec le poids cuit ; donner une fiche recette seulement écrite ; s'arrêter à l'indice de lisibilité pour un public qui ne lit pas ; traiter les apprenants comme des débutants en cuisine ; donner à Mme N. une liste d'interdits ; ajouter du sucre à la salade d'oranges ; évaluer avec un questionnaire écrit.

Corrigé S3 – « Voir avec les mains » : alimentation, information et autonomie de personnes déficientes visuelles

que le jury attend

Le jury évalue la capacité à comprendre qu'une difficulté d'accès à l'information n'est pas toujours liée à la lecture ou à la langue : ici, elle tient au **handicap visuel** et à l'**inaccessibilité** des supports, des produits et des lieux. Il valorise le calcul juste du rapport de contraste et sa lecture critique, la distinction entre ce qui relève des personnes et ce qui relève de l'environnement, des adaptations construites avec des professionnels de la basse vision, et un atelier où la sécurité et l'autonomie sont travaillées sans infantiliser. Il pénalise les supports seulement visuels, les gestes faits « à la place » des personnes et la conclusion abusive d'un risque relatif non significatif.

Temps 1 – Le projet d'intervention

Question 1 – Indicateurs et diagnostic (2,5 pts)

Calcul posé – Indicateurs de l'enquête téléphonique (n = 45)

- Ne peut pas lire les dates : 35 / 45 × 100 = **77,8 %**.
- Ne peut pas lire le tableau nutritionnel : 39 / 45 × 100 = **86,7 %**.
- Utilise une application ou un assistant vocal : 17 / 45 × 100 = **37,8 %**.
- Cuisine seul au moins 4 fois par semaine : 28 / 45 × 100 = **62,2 %**.
- Brûlure ou forte peur de se brûler dans l'année : 20 / 45 × 100 = **44,4 %**.
- Mange surtout des plats préparés : 19 / 45 × 100 = **42,2 %**.
- Satisfait de son alimentation : 22 / 45 × 100 = **48,9 %**.
- Taux de participation : 45 / 120 × 100 = **37,5 %**.

Niveau	Constats
Personnes	Impossibilité de lire l'écrit imprimé pour la plupart (77,8 % ne lisent pas les dates) ; perte de confiance en cuisine (44,4 % de brûlures ou de peur) ; repli sur les plats préparés (42,2 %) ; compétences anciennes à réactiver (Mme L.) ; usage partiel d'outils numériques (37,8 %)
Produits	Dates, prix et tableaux imprimés en petits caractères, souvent sans contraste ; applications de lecture qui lisent tout l'emballage sans hiérarchie (M. T.)
Environnement	Supports de prévention illisibles (dépliant, affiche, site) ; aide en magasin dépendante de la bonne volonté du personnel (Mme G.) ; isolement (58 % vivent seuls)

Diagnostic. L'information alimentaire est **inaccessible** pour la grande majorité des adhérents, non par manque de compétences mais parce que les supports ne sont pas conçus pour eux. Cette inaccessibilité, associée à la peur de se blesser, conduit près d'un adhérent sur deux à se replier sur des plats préparés et à se dire peu satisfait de son alimentation. Le taux de participation (37,5 %) invite à la prudence : les répondants sont peut-être les adhérents les plus actifs.

Question 2 – Contraste et accessibilité des supports (2,5 pts)

Calcul posé – Rapport de contraste (WCAG)

- Support A : (1,000 + 0,05) / (0,216 + 0,05) = 1,05 / 0,266 = **3,95** : inférieur à 4,5, **non conforme** pour un texte courant ; la police de 9 points aggrave le problème.
- Support B : (1,000 + 0,05) / (0,927 + 0,05) = 1,05 / 0,977 = **1,07** : contraste presque nul, **non conforme**, même pour un grand texte (seuil 3).
- Support C : (1,000 + 0,05) / (0,000 + 0,05) = 1,05 / 0,05 = **21,0** : contraste maximal, **conforme** ; police de 16

points.
- Site de la mairie : 5 / 12 × 100 = **41,7 %** des critères respectés ; en ajoutant les textes alternatifs, des liens explicites, les sous-titres et l'audiodescription de la vidéo, et une police agrandissable, on atteindrait par exemple 10 / 12 × 100 = **83,3 %**.

Corrections : texte noir (ou très foncé) sur fond clair uni, ou l'inverse ; police sans empattement de 16 points au moins ; pas d'information donnée seulement par la couleur ; version numérique accessible au lecteur d'écran (titres structurés, textes alternatifs) ; version audio ; pour l'association, version en braille pour les adhérents qui le lisent. L'**indice de Kandel et Moles** mesure la longueur des phrases et des mots : un texte « très facile » au sens de cet indice reste **illisible** s'il est imprimé en gris pâle de 9 points, ou s'il n'existe qu'en image. Pour ce public, l'accessibilité passe par le **format** (contraste, taille, audio, braille, compatibilité avec le lecteur d'écran) autant que par la clarté du texte.

Question 3 – Analyse avec les notions du chapitre (2 pts)

- **Modèle de Sørensen** : la difficulté se situe surtout à l'étape **accéder** (l'information est là, mais impossible à percevoir) ; **comprendre** et **évaluer** sont peu touchés quand l'information est rendue audible ; **appliquer** est freiné par la peur de se blesser.
- **Littératie alimentaire** : les compétences de **préparation** existent ou ont existé (Mme L.) ; la **sélection** (dates, prix, composition) est empêchée par l'étiquetage ; la **planification** est compliquée par la difficulté à faire ses courses seul.
- **Littératie numérique** : les outils (lecteur d'écran, reconnaissance de texte) sont de vraies aides, mais ils demandent un apprentissage et lisent tout sans hiérarchie : il faut apprendre à les utiliser et à chercher l'information utile (date, allergènes).
- **Littératie organisationnelle** : la mairie, le supermarché et les fabricants ont la responsabilité de rendre l'information accessible (loi de 2005, RGAA, Acte européen sur l'accessibilité depuis 2025).
- **Précautions universelles** : un support conçu pour être lisible par des personnes malvoyantes (contraste, taille, audio) est plus lisible pour tous, en particulier pour les personnes âgées.

Question 4 – Objectifs, plan d'action et budget (4 pts)

Objectif général : améliorer l'autonomie alimentaire et la sécurité en cuisine des adhérents de l'association, en un an.

Objectif	Indicateur	Départ	Cible	Échéance
Spécifique 1 : permettre aux adhérents de lire les informations utiles des emballages (dates, allergènes, prix)	Part des adhérents qui déclarent pouvoir lire les dates (avec ou sans outil)	22,2 %	50 %	12 mois
Spécifique 2 : renforcer la sécurité et la confiance en cuisine	Part des adhérents qui déclarent une brûlure ou une forte peur de se brûler	44,4 %	30 %	12 mois
Opérationnel 1 : animer 8 ateliers culinaires adaptés de 6 personnes avec l'ergothérapeute	Nombre d'ateliers et de participants	0	8 ateliers, 30 adhérents différents	10 mois
Opérationnel 2 : organiser 4 sessions d'apprentissage d'une application de lecture d'étiquettes gratuite	Nombre de participants capables de lire une date avec l'application	0	20	6 mois
Opérationnel 3 : produire 10 recettes en version audio et en gros caractères à fort contraste	Nombre de recettes ; contraste ≥ 4,5 ; test auprès de 5 adhérents	0	10 recettes testées	8 mois
Opérationnel 4 : obtenir du supermarché une aide aux courses sur rendez-vous et du centre communal d'action sociale une version accessible de ses supports	Conventions ou engagements signés	0	2	12 mois

Poste	Coût
Denrées pour 8 ateliers (environ 25 € par atelier, plus 300 € pour les repas partagés)	500 €
Matériel adapté (gants anti-chaleur longs, planches contrastées, couteaux protégés, détecteur de niveau de liquide, minuteurs parlants, étiquettes en relief)	300 €
Enregistrement audio et impression en gros caractères des recettes	240 €
Transcription en braille (prestataire)	280 €
Sessions d'apprentissage numérique (bénévoles formés, matériel de démonstration)	200 €
Transport accompagné pour les participants isolés	180 €
Formation courte des bénévoles au guidage	150 €
Communication et événement de restitution	150 €
Total	**2 000 €**

Vérification : 500 + 300 + 240 + 280 + 200 + 180 + 150 + 150 = **2 000 €** ✓.

Question 5 – Risque relatif, intervalle de confiance et taille d'échantillon (3 pts)

Calcul posé – Brûlures selon la cuisine solitaire

Notations : a = 16, a + b = 28 ; c = 4, c + d = 17.

- Risque chez ceux qui cuisinent seuls au moins 4 fois par semaine : 16 / 28 = **57,1 %** ; chez les autres : 4 / 17 = **23,5 %**.
- RR = 0,571 / 0,235 = **2,43**.
- ln RR = 0,887 ; erreur type = √(1/16 − 1/28 + 1/4 − 1/17) = √0,2180 = **0,467**.
- IC 95 % = exp(0,887 ± 1,96 × 0,467) = exp(0,887 ± 0,915) = [exp(− 0,028) ; exp(1,802)] = **[0,97 ; 6,06]**.

Le risque est 2,4 fois plus élevé chez les adhérents qui cuisinent souvent seuls, mais l'intervalle de confiance **contient 1** : l'association n'est **pas statistiquement significative** au seuil de 5 % avec seulement 45 répondants. On ne peut donc ni conclure à un lien ni l'exclure. Interprétation logique : plus on cuisine, plus on s'expose au risque ; cela ne veut pas dire qu'il faut cuisiner moins, mais qu'il faut cuisiner **en sécurité**.

Calcul posé – Proportion d'adhérents qui ne peuvent pas lire le tableau nutritionnel

- p = 39 / 45 = **0,867** ; demi-largeur = 1,96 × √(0,867 × 0,133 / 45) = 1,96 × √0,002567 = 1,96 × 0,0507 = **0,099**.
- IC 95 % = **[76,7 % ; 96,6 %]**.
- n0 = 1,96² × 0,867 × 0,133 / 0,05² = **178** ; correction pour 120 adhérents : n = 178 / (1 + 177 / 120) = 178 / 2,475 = **72** adhérents.

Question 6 – Veille (2 pts)

Sources : Fédération des aveugles et amblyopes de France et grandes associations nationales de la déficience visuelle (guides d'accessibilité) ; direction interministérielle du numérique (RGAA) ; W3C (WCAG) ; Défenseur des droits ; Santé publique France (« Communiquer pour tous ») ; Haute Autorité de santé ; centres de rééducation basse vision ; textes européens sur l'accessibilité. Outils : lettres d'information, alertes, flux RSS **compatibles avec le lecteur d'écran**. Fréquence : mensuelle pour les textes et les outils ; à chaque projet pour les guides. Diffusion : synthèse audio et en gros caractères pour le bureau de l'association.

Question 7 – Situations éthiques et accessibilité de l'exposé (2 pts)

- **Financement contre recommandation d'une application payante** : conflit d'intérêts ; l'association ne peut pas recommander un produit en échange d'un financement ; il existe des applications gratuites, et le choix

doit se faire selon les besoins de chacun. Réponse : refus du financement conditionnel ; un partenariat serait possible sans contrepartie publicitaire, avec une information sur plusieurs outils.

- **Vidéo diffusée publiquement** : **droit à l'image** ; il faut l'autorisation écrite de chaque personne filmée, après une information claire (et accessible : lue à voix haute) sur la diffusion ; le respect de la dignité exclut les images de gestes maladroits ou d'accidents. On peut proposer une vidéo centrée sur les mains et les ustensiles, avec audiodescription, validée par les participants.
- **Exposé accessible** : diaporama à fort contraste, police de grande taille, chaque visuel **décrit oralement** ; documents remis en version numérique accessible au lecteur d'écran ; présence possible d'un adhérent pour témoigner.

Temps 2 – L'atelier culinaire

Question 8 – Besoins et objectifs (2 pts)

Besoins : retrouver la confiance et la sécurité pour cuisiner ; recevoir l'information sous une forme accessible (orale, tactile, gros caractères) ; partager un repas (isolement) ; tenir compte du diabète de Mme L. et de l'hypertension de M. B. Objectif général : permettre aux participants de réaliser en sécurité un repas complet et simple, qu'ils pourront refaire seuls chez eux. Objectifs opérationnels : 1. chaque participant utilise au moins deux aides techniques (gant long, détecteur de niveau, minuteur parlant) ; 2. chaque participant réalise seul, après démonstration tactile, une étape de la recette (râper, mesurer la semoule, verser l'eau chaude, enfourner) ; 3. chaque participant décrit à l'oral la composition de son assiette en se repérant « en horloge ».

Question 9 – Bon de commande, coût et apports (4 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 10 portions

Denrée	Net pour 10	Perte	Brut pour 10	Coût
Filet de poulet	1 000 g	0 %	1 000 g	1,000 × 11,50 = 11,50 €
Yaourt nature	300 g	0 %	300 g (3 pots de 100 g ou 2,4 pots de 125 g)	0,300 × 2,20 = 0,66 €
Citron (jus)	50 g	60 %	50 / 0,40 = 125 g (1 citron)	0,125 × 3,00 = 0,38 €
Huile de colza	50 g	0 %	50 g	0,050 × 3,20 = 0,16 €
Semoule	600 g	0 %	600 g	0,600 × 1,90 = 1,14 €
Carottes	1 000 g	15 %	1 000 / 0,85 = 1 176 g	1,176 × 1,40 = 1,65 €
Oranges à jus (jus)	300 g	55 %	300 / 0,45 = 667 g	0,667 × 2,00 = 1,33 €
Bananes	800 g	35 %	800 / 0,65 = 1 231 g	1,231 × 2,00 = 2,46 €
Fromage blanc 2-3 %	1 000 g	0 %	1 000 g	1,000 × 2,60 = 2,60 €
Ail, épices, persil, sel	–	–	–	0,90 €

Total : 11,50 + 0,66 + 0,38 + 0,16 + 1,14 + 1,65 + 1,33 + 2,46 + 2,60 + 0,90 = **22,78 €** ; par portion : **2,28 €**, sous le plafond de 2,50 €.

Calcul posé – Apport d'une portion (Ciqual 2025)

Aliment (quantité)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Poulet (100 g)	110,0	23,40	0	0	1,50	0	0,11
Yaourt (30 g)	15,0	1,15	1,28	1,20	0,50	0	0,03
Jus de citron (5 g)	1,5	0,02	0,30	0,12	0,01	0,02	0
Huile de colza (5 g)	45,0	0	0	0	5,00	0	0
Semoule crue (60 g)	210,0	7,08	41,88	0,60	0,77	2,22	0
Carotte (100 g)	30,2	0,78	5,16	4,85	0	2,90	0,12

Aliment (quantité)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Jus d'orange (30 g)	13,6	0,18	2,88	2,88	0,03	0,08	0
Banane (80 g)	70,1	0,85	15,76	12,48	0	2,16	0
Fromage blanc (100 g)	75,7	7,28	3,86	3,86	3,23	0,02	0,09
Total	**571,1**	**40,74**	**71,13**	**25,99**	**11,05**	**7,40**	**0,36**

Répartition : protéines 40,74 × 4 / 571,1 × 100 = **28,5 %** ; glucides 71,13 × 4 / 571,1 × 100 = **49,8 %** ; lipides 11,05 × 9 / 571,1 × 100 = **17,4 %**.

Commentaire : repas riche en protéines (poulet et fromage blanc), pauvre en lipides et très pauvre en sel (0,36 g sans sel ajouté), avec des fibres modérées (7,4 g) qu'on pourrait augmenter avec une semoule complète ou des pois chiches dans la semoule. Les sucres (26 g) viennent de la banane, des carottes, du jus d'orange et du fromage blanc : aucun sucre ajouté. Pour **Mme L.** (diabète), le dessert ne contient pas de sucre ajouté ; la banane bien mûre élève plus la glycémie qu'une banane juste mûre ; la portion de semoule peut être ajustée avec elle. Pour **M. B.** (hypertension), le repas est un bon exemple de plat savoureux sans sel ajouté grâce au citron, à l'ail, au cumin et au persil : on sale à table, avec modération, après avoir goûté.

Question 10 – Fiche technique, recette accessible, adaptations (4 pts)

Modèle – Fiche technique : poulet mariné au yaourt et au citron, semoule, carottes râpées à l'orange (10 portions)

Ingrédients : 1 kg de filets de poulet ; 300 g de yaourt ; jus d'un citron ; 2 gousses d'ail ; 2 cuillères à café de cumin ; 50 g d'huile ; 600 g de semoule ; 600 mL d'eau bouillante ; 1,2 kg de carottes ; jus de 3 oranges ; persil ; 1 kg de fromage blanc ; 1,2 kg de bananes ; cannelle.

Étapes : 1. Couper le poulet en lanières (fait par le candidat ou un bénévole avant l'atelier, ou par un participant avec un couteau à garde et une planche contrastée). 2. Mélanger yaourt, citron, ail, cumin ; enrober le poulet ; laisser mariner 30 minutes au réfrigérateur. 3. Cuire au four à 200 °C pendant 18 à 20 minutes ; vérifier 75 °C à cœur avec un thermomètre parlant. 4. Verser l'eau bouillante sur la semoule avec l'huile, couvrir 5 minutes, égrener à la fourchette. 5. Râper les carottes avec une râpe à réservoir, arroser de jus d'orange. 6. Écraser les bananes à la fourchette, mélanger au fromage blanc, saupoudrer de cannelle.

Points critiques : volaille crue séparée et ustensiles dédiés ; cuisson à cœur ; liquide bouillant ; four chaud ; lames.

Version accessible de la recette : **audio** (enregistrement de 3 minutes, une étape par piste, phrases courtes, quantités en objets : « un pot de yaourt », « un verre de semoule par personne ») ; **gros caractères** (police sans empattement de 18 points, noir sur jaune pâle ou blanc sur noir, une étape par page) ; **braille** pour les adhérents qui le lisent ; **repères tactiles** (gommettes en relief sur le bouton du four à 200 °C, élastique sur le flacon de cumin).

Adaptations proposées avec l'ergothérapeute : poste toujours organisé de la même façon (ingrédients à gauche, outils à droite, « ce qui est utilisé retourne à sa place ») ; plateau à rebords pour contenir les débordements ; planche de couleur contrastée (blanche pour les carottes, noire pour l'oignon) ; **râpe à réservoir** et gant anti-coupure ; **détecteur de niveau de liquide** sur la tasse pour verser l'eau bouillante, bouilloire posée sur un plateau ; **gants longs** pour le four, grille sortie avant de saisir le plat ; minuteur parlant ; doigt guide et gestes « main sur main » proposés seulement avec l'accord de la personne.

Question 11 – Déroulé, méthodes et dégustation (4 pts)

Horaire	Candidat	Participants
8 h 30 – 9 h 15	Mise en place : postes identiques, ustensiles alignés, détecteurs et minuteurs testés, poulet découpé si besoin	–
9 h 15 – 9 h 35	Accueil, présentation orale de chacun ; visite tactile du poste (« la planche est devant vous, le couteau à droite, pointe vers le mur »)	Explorent le poste avec les mains
9 h 35 – 9 h 50	Marinade : description précise des gestes, démonstration tactile	Mélangent la marinade, enrobent le poulet
9 h 50 – 10 h 20	Carottes et bananes : utilisation de la râpe à réservoir et du gant	Râpent, écrasent, mélangent
10 h 20 – 10 h 45	Four : enfourner avec l'ergothérapeute ; semoule avec le détecteur de niveau	Enfournent à tour de rôle, versent l'eau chaude
10 h 45 – 11 h 05	Pendant la cuisson : échange sur les applications de lecture d'étiquettes (démonstration sur une boîte de semoule)	Lisent une date avec l'application
11 h 05 – 11 h 45	Service, repérage de l'assiette « en horloge » (poulet à midi, semoule à 4 h, carottes à 8 h), repas partagé, dégustation orale	Décrivent, goûtent, commentent
11 h 45 – 12 h 00	« Faire dire » et « faire faire » : chacun explique une astuce de sécurité	Expliquent ; reçoivent la recette audio
12 h 00 – 12 h 15	Remise en état	Participent

Méthodes : **guidage verbal précis** (positions, distances, « à votre droite », jamais « là ») ; démonstration tactile ; **main sur main** seulement avec accord ; « faire dire » (« Comment allez-vous savoir que le poulet est cuit ? ») et « faire faire ». Grille de dégustation orale : pour chaque plat, une note de 1 à 5 dite à voix haute, et deux questions (« Qu'avez-vous aimé ? » ; « Que changeriez-vous ? »), notées par un bénévole.

Question 12 – Hygiène, sécurité, allergènes, éco-gestes (3 pts)

Hygiène : lavage des mains guidé (savon et serviette toujours au même endroit) ; volaille crue sur une planche dédiée, puis lavage des mains ; marinade au réfrigérateur ; cuisson à cœur (75 °C) vérifiée au thermomètre parlant ; produits laitiers au froid. Sécurité : rangement constant ; couteaux rangés à plat dans un bac ; jamais de liquide chaud porté à bout de bras ; poignées des casseroles tournées vers l'intérieur ; four ouvert par l'animateur ou avec l'ergothérapeute ; annonce orale de chaque déplacement (« Je passe derrière vous avec le plat chaud »). Allergènes : **lait** (yaourt, fromage blanc), **gluten** (semoule de blé) ; signalés oralement et en gros caractères. Éco-gestes : carottes et bananes de saison ou de proximité si possible ; épluchures au compost ; four utilisé à pleine charge ; restes répartis en boîtes pour les participants.

Question 13 – Réalisation et évaluation (3 pts)

Réalisation : poulet doré, tendre et cuit à cœur ; semoule égrenée ; carottes finement râpées, juteuses ; dessert onctueux, banane non oxydée (préparée au dernier moment ou citronnée). Évaluation : nombre d'aides techniques utilisées par chaque participant ; nombre d'étapes réalisées seul ; incidents (brûlure, coupure : objectif zéro) ; notes de dégustation ; question « Pensez-vous refaire une partie de ce repas chez vous ? » ; appel téléphonique trois semaines plus tard : « L'avez-vous refait ? Qu'est-ce qui vous a aidé ? ».

Barème – Barème du sujet mixte

Temps 1 : indicateurs et diagnostic 2,5 ; contraste et accessibilité 2,5 ; analyse 2 ; objectifs, plan et budget 4 ; statistiques 3 ; veille 2 ; éthique et exposé 2 ; expression et sources 2 ; total 20.

Temps 2 : besoins et objectifs 2 ; bon de commande et apports 4 ; fiche technique, recette accessible et adaptations 4 ; déroulé, méthodes et dégustation 4 ; hygiène et sécurité 3 ; réalisation et évaluation 3 ; total 20.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Inverser L1 et L2 dans le calcul du contraste ; conclure que le support A est « presque conforme » ; s'arrêter à la lisibilité du texte sans regarder le format ; conclure à un lien significatif alors que l'intervalle contient 1 ; faire les gestes à la place des participants ; guider avec des mots comme « ici » ou « là » ; oublier les pertes du citron, des oranges et des bananes ; oublier le gluten de la semoule ; accepter une recommandation commerciale en échange d'un financement.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Ce que je sais faire	Sujet	Acquis	En cours	À retravailler
C3.1	Calculer et interpréter des indicateurs de littératie et d'accès à l'information ; comparer avec HLS19	S1, S3			
C3.1	Classer des difficultés selon le modèle de Sørensen et les niveaux de Nutbeam	S1, S3			
C3.1	Calculer un indice de lisibilité et l'interpréter avec un test de compréhension	S1, S2			
C3.1	Calculer un rapport de contraste et un taux de conformité d'accessibilité	S3			
C3.1	Formuler des objectifs avec indicateur, cible et échéance ; construire un budget	S1, S3			
C3.2	Établir un bon de commande avec quantités brutes et nettes et vérifier un budget	S2, S3			
C3.2	Calculer des apports avec la table Ciqual 2025 (dont fer et vitamine C) et les commenter	S2, S3			
C3.2	Concevoir une fiche recette accessible (images, objets, audio, gros caractères, braille)	S2, S3			
C3.2	Adapter un atelier à des apprenants allophones et à des personnes déficientes visuelles	S2, S3			
C3.2	Appliquer l'hygiène et la sécurité (conserves, riz cuit, volaille, brûlures, coupures)	S2, S3			
C3.3	Calculer un risque relatif et son intervalle de confiance ; distinguer significatif et non significatif	S1, S3			
C3.3	Calculer un intervalle de confiance et une taille d'échantillon corrigée	S1, S3			
C3.4	Organiser une veille sur la littératie, l'accessibilité et un public spécifique	S1, S3			
C3.5	Choisir des supports et des canaux adaptés (oral, vidéo, audio, pictogrammes, médiation)	S1, S2, S3			
C3.6	Respecter le secret professionnel, les données personnelles, le droit à l'image ; refuser un conflit d'intérêts	S1, S3			

Modèles officiels utilisés : structure des sujets U62 (2002-2014) et E5.B (2021-2024) pour le bon de commande, la fiche technique et l'organisation ; BTS blanc CNED E5B pour l'adaptation d'une recette et le calcul nutritionnel ; texte de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024) pour la répartition des compétences entre les deux temps.

DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE

CHAPITRE 6

Éthique et déontologie en santé publique

Mots-clés : Valeurs, Principes, Secret, Données, Image, Conflits d'intérêts

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 6 · Éthique et déontologie en santé publique · version normale

1 COURS

Mise en page normale · 95 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 98

2 FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 7 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 99 à 105

3 CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 121 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 106 à 226

4 ANNALES E5

Mise en page normale · 38 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 227 à 264

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 · Cours **4**

6.1 Compétences mobilisées 6
6.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6
6.3 Cours 8
6.4 Approfondissements 72
6.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 79
6.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 80
6.7 L'essentiel à retenir 85
6.8 Entraînement 86
6.9 Glossaire 96
6.10 Renvois bibliographiques par notion 97
6.12 Bibliographie numérotée 97

2 · Fiche de révision et fiches-outils **99**

Fiche de révision du chapitre 6 101
1. Les définitions à savoir 101
2. Les principes 101
3. Les textes et chiffres-clés 102
4. Les réflexes en action collective 102
5. Les pièges 102
6. Auto-test 102
7. Flashcards 102
Compléments du chapitre enrichi 103
Fiches-outils du chapitre 6 103
O6.1 – Autorisation de droit à l'image 103
O6.2 – Check-list RGPD d'un questionnaire ou d'un fichier 104
O6.3 – Analyse d'un partenariat 104
O6.4 – Grille d'analyse d'un dilemme éthique 105
O6.5 – Check-list « message non stigmatisant » 105

3 · Cahier d'exercices **106**

Cahier d'exercices – Chapitre 6 109
Partie 1 – Les fondements : éthique, principes et stigmatisation 111
Partie 2 – Le cadre professionnel et le secret 124
Partie 3 – Protéger les données personnelles (RGPD) 140
Partie 4 – Le consentement et le droit à l'image 155
Partie 5 – Conflits d'intérêts et partenariats 169
Partie 6 – Allégations, publicité et compléments alimentaires 182
Partie 7 – Enquêtes, recherche et identité numérique 198
Partie 8 – Synthèse : droits, responsabilité, dignité et cas complet 211
Bilan : grille d'auto-évaluation 226

4 · Annales E5 ..... **227**

Cahier d'annales E5 – chapitre 6 229
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 231
Partie II – Les corrigés détaillés 244
Grille d'auto-évaluation 264

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS

CHAPITRE

06

Éthique et déontologie en santé publique

Valeurs | Principes | Secret | Données | Image

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

6.1 Compétences mobilisées ... 6
6.2 Croisement référentiel × précisions × indications ... 6
6.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 ... 7
6.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED ... 7
6.3 Cours ... 8
6.3.1 Morale, éthique, déontologie, droit ... 8
6.3.2 Les principes éthiques ... 12
6.3.3 Le cadre professionnel du diététicien ... 20
6.3.4 Le secret professionnel et la confidentialité ... 24
6.3.5 La protection des données personnelles (RGPD) ... 28
6.3.6 Le consentement et le droit à l'image ... 34
6.3.7 Les conflits d'intérêts ... 38
6.3.8 Une démarche de réflexion éthique ... 41
6.3.9 Les droits des usagers et la démocratie en santé ... 45
6.3.10 La responsabilité du professionnel dans une action collective ... 50
6.3.11 Publicité, allégations et compléments alimentaires : repères pour une information loyale ... 54
6.3.12 Enquêtes, recherche et protection des personnes ... 59
6.3.13 Identité numérique et e-réputation du professionnel ... 63
6.3.14 Cinq dilemmes éthiques commentés ... 65
6.3.15 Laïcité et neutralité dans les actions de santé publique ... 68
6.3.16 Fil rouge : les choix éthiques d'Inès ... 70
6.3.17 Cas guidé : repérer la dénutrition des seniors à domicile ... 70
6.4 Approfondissements ... 72
6.4.1 Le diététicien sur les réseaux sociaux ... 72
6.4.2 Les partenariats public-privé en nutrition ... 73
6.4.3 La participation des personnes : une exigence éthique ... 75
6.4.4 Éthique et intelligence artificielle en santé ... 76
6.4.5 Le consentement des personnes vulnérables ... 77
6.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 ... 79
6.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles ... 80
Méthodes pour l'épreuve E5 : réussir les questions d'éthique ... 81
Méthode 5 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve ... 82
Méthode 6 – Relier l'éthique aux autres chapitres du cours ... 83
Méthode 7 – Savoir à qui s'adresser : les autorités et leurs rôles ... 84
6.7 L'essentiel à retenir ... 85
6.8 Entraînement ... 86
6.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) ... 86
6.8.2 Exercices ... 88
6.8.3 Questions de réflexion ... 91
6.8.4 Étude de cas ... 92
6.8.5 Mises en situation express ... 92
6.8.6 Exercices complémentaires ... 95
6.9 Glossaire ... 96
6.10 Renvois bibliographiques par notion ... 97
6.12 Bibliographie numérotée ... 97

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- distinguer morale, éthique, déontologie et droit ;
- mobiliser les principes éthiques (autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice) et ceux propres à la santé publique (proportionnalité, moindre contrainte, équité, transparence) ;
- situer une action sur l'échelle d'intervention et en discuter la légitimité (information, nudge, incitation, réglementation) ;
- connaître le cadre professionnel du diététicien (Code de la santé publique, code de déontologie) ;
- respecter le secret professionnel et le partage d'informations dans une action collective ;
- appliquer le RGPD à un questionnaire, à un fichier de participants ou à une évaluation ;
- recueillir un consentement et une autorisation de droit à l'image, y compris pour des mineurs ;
- repérer et gérer un conflit d'intérêts (partenariats, sponsors, industrie agroalimentaire) ;
- conduire une démarche de réflexion éthique face à un dilemme de terrain.

6.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.1	Conduire un projet dans le respect des obligations éthiques, juridiques et déontologiques	Règles éthiques, juridiques et déontologiques respectées
C3.2	Animer des ateliers respectueux (confidentialité, non-stigmatisation, allergènes, neutralité)	Méthodes d'animation appropriées ; hygiène et sécurité respectées
C3.3	Recueillir et traiter des données de santé (questionnaires, enquêtes) conformément au RGPD	Règles de déontologie et d'éthique prises en compte ; principes éthiques du traitement des données numériques en santé maîtrisés
C3.5	Communiquer dans le respect du droit à l'image, de l'e-réputation et du secret	Réglementation (RGPD, droit à l'image) ; enjeux de l'e-réputation pris en compte ; posture adaptée
C3.6	Protéger les fichiers et les données personnelles	Environnement numérique géré et sécurisé

6.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Éthique, morale, déontologie, droit	Définir et distinguer	Pas de cours de philosophie ; exemples professionnels
Principes éthiques	Mobiliser les 4 principes dans une situation	Beauchamp et Childress ; éthique de santé publique
Cadre de la profession	Citer les textes essentiels	Code de la santé publique (L. 4371-1 et suivants) ; code de déontologie
Secret professionnel, confidentialité	Appliquer en action collective	L. 1110-4 CSP ; article 226-13 du Code pénal
Protection des données	Appliquer les principes du RGPD	Règlement (UE) 2016/679 ; CNIL ; anonymat
Droit à l'image, consentement	Rédiger une autorisation	Article 9 du Code civil ; mineurs
Conflits d'intérêts	Repérer, déclarer, gérer	Partenariats avec l'industrie ; transparence

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Démarche de réflexion éthique	Analyser un dilemme et justifier une décision	Grille d'analyse

6.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : bloc 3, savoirs « Éthique et déontologie ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 61). Les dates et les textes ont été comparés à la dernière version en vigueur au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 6.2.2.

Texte	Critère ou indication	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 61	Posture professionnelle : savoir-être	6.3.2 (la posture professionnelle) ; 6.3.10 ; 6.3.14
Guide 2025, p. 61	Règles d'éthique : équité, justice sociale, bienveillance, autonomie individuelle et de groupe	6.3.2 (principes éthiques et tableau des quatre valeurs) ; 6.3.8 (démarche de réflexion éthique)
Guide 2025, p. 61	Code de déontologie : principes et valeurs	6.3.3 (cadre professionnel, charte de l'AFDN) ; 6.3.4 (secret) ; 6.3.7 (conflits d'intérêts)
Référentiel, C3.1	Règles éthiques, juridiques et déontologiques respectées dans le projet	6.3.5, 6.3.6, 6.3.9, 6.3.12 ; 6.6
Référentiel, C3.5	Communication respectant le droit à l'image, l'e-réputation et le secret	6.3.6 ; 6.3.11 ; 6.3.13 ; 6.4.1

6.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié par rapport au fascicule *Environnement professionnel – Les essentiels*, 2e année (CNED 3-6124-AN-WT-00-21, © 2022), module 1, séquence 2 « Outils, ressources et méthodologies en santé publique » (p. 11) et séquence 6 « Démocratie sanitaire : droits des usagers et patients » (p. 22 à 24). La séquence 7 « Santé et numérique » est traitée au chapitre 20.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Essentiels M1 S2 §2 (p. 11)	Cadre d'un projet sanitaire : Code de la santé publique, règles, textes de référence, recommandations, codes de déontologie, éthique, secret professionnel	6.3.1 (morale, éthique, déontologie, droit) ; 6.3.3 ; 6.3.4
Essentiels M1 S6 §1 (p. 22)	Démocratie sanitaire : loi du 4 mars 2002, loi du 26 janvier 2016	6.3.9 (grands textes, définition de la démocratie en santé)
Essentiels M1 S6 §2.1 et §2.2 (p. 22 et 23)	Droits fondamentaux ; droits collectifs et individuels (droit à l'oubli, action de groupe, information, consentement, accès au dossier, secret)	6.3.4 ; 6.3.6 ; 6.3.9 (droit à l'oubli et action de groupe)
Essentiels M1 S6 §2.3 (p. 23 et 24)	Outils de la loi du 2 janvier 2002 (charte, document individuel, personne qualifiée, CVS, règlement de fonctionnement, projet d'établissement) ; loi HPST	6.3.9 (loi du 2 janvier 2002, CVS ; loi HPST) ; 6.3.10

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou était inexact

- **Droit à l'oubli** (p. 23) : le délai de « dix ans » est dépassé. Depuis la loi du 28 février 2022 (applicable au 1er juin 2022), il est de **5 ans** après la fin du protocole thérapeutique, pour les cancers et l'hépatite C.

- **Action de groupe** (p. 23) : le régime de 2016 a été remplacé par un régime unique (loi du 30 avril 2025, pour les actions introduites depuis le 2 mai 2025).
- **Loi « HSPT »** (p. 24) : il s'agit de la loi **HPST** (« Hôpital, patients, santé et territoires ») du 21 juillet 2009, publiée au *Journal officiel* du 22 juillet 2009.
- **Code de déontologie** (p. 11) : pour les diététiciens, il n'existe pas de code publié par décret ni d'ordre professionnel ; le texte de référence est la charte de déontologie de l'AFDN (2018).
- **Consentement et données** (p. 27, séquence 7) : le fascicule a raison de distinguer le consentement aux soins et la base légale du traitement des données ; en action collective (enquête, atelier), le traitement repose le plus souvent sur une autre base que le consentement, mais l'information des personnes reste obligatoire (chapitre 6.3.5).

6.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Code de déontologie** : le texte de l'AFDN en ligne en octobre 2026 est la « Charte de déontologie du diététicien-nutritionniste » du 1er janvier 2018 ; il n'existe pas de code réglementaire publié par décret pour les diététiciens.
- **Données personnelles** : le RGPD (règlement (UE) 2016/679) s'applique depuis le 25 mai 2018 ; les guides pratiques et les méthodologies de référence de la CNIL sont régulièrement mis à jour (*cnil.fr*).
- **Intelligence artificielle** : le règlement (UE) 2024/1689 s'applique par étapes (interdictions depuis le 2 février 2025, obligations de transparence depuis le 2 août 2026) ; le règlement « omnibus » (UE) 2026/1744 du 24 juillet 2026 a reporté les obligations des systèmes à haut risque au 2 décembre 2027 et au 2 août 2028.
- **Influence commerciale** : la loi du 9 juin 2023 encadre l'activité des influenceurs ; elle a été modifiée par une ordonnance du 6 novembre 2024 pour la rendre conforme au droit européen.

6.3.1 Morale, éthique, déontologie, droit

Module · Référentiel et guide : voir 6.2.1 · CNED : Essentiels M1 S2 §2 (p. 11)

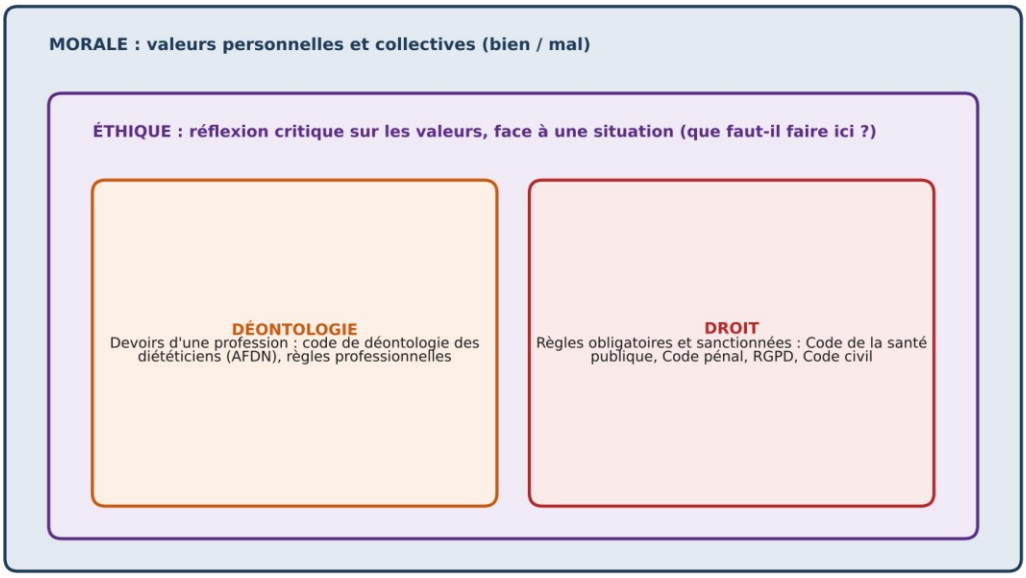


Figure 6.1 – Morale, éthique, déontologie et droit

Comprendre le schéma – Figure 6.1

1. La **morale** désigne l'ensemble des valeurs et des normes qui distinguent le bien du mal, dans une société ou pour une personne ; elle est souvent vécue comme évidente.
2. L'**éthique** est une **réflexion critique** sur ces valeurs, à l'occasion d'une situation concrète : « Que faut-il faire ici, et pourquoi ? ». Elle intervient surtout quand plusieurs valeurs légitimes entrent en **tension** (respecter le choix d'une personne et la protéger).
3. La **déontologie** (du grec *deon*, « ce qu'il faut faire ») rassemble les **devoirs** d'une profession envers les personnes, les collègues et la société ; pour les diététiciens, elle est formalisée par un **code de déontologie** porté par l'association professionnelle (AFDN).
4. Le **droit** fixe des règles **obligatoires** et **sanctionnées** par l'État (Code de la santé publique, Code pénal, Code civil, RGPD).
5. Les quatre niveaux s'emboîtent : une conduite peut être légale mais discutable sur le plan éthique (une campagne culpabilisante), ou déontologiquement exigée au-delà de la loi (se former en continu).

Définition – Éthique (définition opérationnelle)

Démarche de **questionnement** et de **délibération** qui vise à déterminer, dans une situation donnée, la conduite la plus juste, en prenant en compte les valeurs en présence, les règles applicables et les conséquences pour les personnes concernées.

Trois grandes façons de raisonner en éthique

Face à une même situation, on peut raisonner de plusieurs manières. Connaître les trois grands courants de la philosophie morale aide à comprendre pourquoi deux professionnels de bonne foi n'arrivent pas toujours à la même conclusion, et à construire une argumentation plus solide.

Courant	Question posée	Auteurs de référence (dates)	Exemple en nutrition
Éthique des conséquences (conséquentialisme, utilitarisme)	Quelle action produit le plus de bien et le moins de mal pour l'ensemble des personnes concernées ?	Jeremy Bentham (1789), John Stuart Mill (*L'Utilitarisme*, 1861)	Une taxe sur les boissons sucrées est justifiée si elle réduit la consommation et les maladies dans la population, même si certains consommateurs la trouvent injuste.
Éthique du devoir (déontologisme)	Quelle règle dois-je respecter, quelles que soient les conséquences ?	Emmanuel Kant (*Fondements de la métaphysique des mœurs*, 1785)	On ne ment pas à un participant pour le motiver (« ce gâteau est sans sucre »), même si le mensonge pourrait l'aider à changer.
Éthique des vertus	Que ferait ici un professionnel prudent, honnête, juste et bienveillant ?	Aristote (*Éthique à Nicomaque*, IVe siècle av. J.-C.)	Le diététicien adapte son conseil avec tact et prudence, sans appliquer mécaniquement une règle.

Le **conséquentialisme** a l'avantage d'être tourné vers les résultats, ce qui correspond bien à la santé publique, qui raisonne sur des populations. Sa limite est qu'il peut justifier de sacrifier une minorité pour le bien du plus grand nombre (stigmatiser les personnes en situation d'obésité « pour faire peur » et faire baisser la prévalence).

Le **déontologisme** protège la dignité de chaque personne. La formule de Kant le résume : il faut toujours traiter l'humanité, en soi et en autrui, « comme une fin, et jamais simplement comme un moyen ». Sa limite est la rigidité : deux devoirs peuvent s'opposer (dire la vérité et protéger une personne fragile).

L'**éthique des vertus** s'intéresse à la personne qui agit plutôt qu'à la règle ou au résultat. Elle insiste sur la **prudence** (en grec *phronesis*), c'est-à-dire la capacité de juger ce qui convient dans une situation particulière. C'est la vertu que l'on attend d'un professionnel expérimenté.

Les quatre principes de Beauchamp et Childress (6.3.2) empruntent aux trois courants : la bienfaisance et la non-malfaisance regardent les conséquences, l'autonomie et la justice expriment des devoirs envers les personnes, et l'arbitrage entre principes demande de la prudence.

Exemple – Une même question, trois raisonnements

Situation : une cantine scolaire envisage de supprimer le ketchup et la mayonnaise, que les élèves réclament.

- **Raisonnement par les conséquences** : la mesure réduit la consommation de sucres et de matières grasses ajoutés, mais elle risque d'augmenter le gaspillage si les élèves mangent moins. On compare les deux effets à partir de données (pesées des restes avant et après).
- **Raisonnement par le devoir** : la collectivité a le devoir de servir des repas conformes aux recommandations ; elle a aussi le devoir de respecter les goûts des enfants et de les associer aux décisions qui les concernent.
- **Raisonnement par les vertus** : un professionnel prudent cherche une solution mesurée, par exemple une sauce maison au yaourt et aux herbes, des sauces proposées une fois par semaine, et une explication donnée aux élèves.

Conclusion : les trois raisonnements se complètent. Une décision solide les combine.

Attention – Ne pas confondre éthique et opinion personnelle

Dire « je trouve que » ne suffit pas à faire une réflexion éthique. Une argumentation éthique s'appuie sur des **principes nommés**, sur des **faits vérifiés** et sur les **conséquences** pour chaque personne concernée. À l'épreuve E5, le jury attend une argumentation, pas un avis.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.1

Un centre de loisirs veut afficher dans le réfectoire le poids de chaque enfant pour « motiver les familles ». Pour chacun des trois courants (conséquences, devoir, vertus), rédigez une phrase qui montre pourquoi le projet pose problème.

Corrigé

Conséquences : l'affichage risque de provoquer moqueries, honte, restriction alimentaire et troubles du comportement alimentaire, sans preuve d'efficacité ; le bilan attendu est négatif. **Devoir** : l'enfant serait utilisé comme un moyen de pression sur sa famille, au mépris de sa dignité et de sa vie privée ; c'est aussi une donnée de santé diffusée sans base légale. **Vertus** : un professionnel bienveillant et prudent ne pèserait jamais un enfant en public et chercherait à améliorer l'environnement (repas, activité) plutôt qu'à désigner les enfants.

Repères historiques : comment l'éthique en santé s'est construite

L'éthique de la santé est née en grande partie de **scandales**. Connaître ces dates aide à comprendre pourquoi les règles actuelles sur le consentement et la recherche sont si strictes.

Date	Texte ou événement	Ce qu'il apporte
Ve siècle av. J.-C.	Serment d'Hippocrate	Ne pas nuire, respecter le secret de ce que l'on voit et entend
1947	Code de Nuremberg, rédigé après le procès des médecins nazis	Le consentement volontaire de la personne est « absolument essentiel » à toute expérimentation
1948	Déclaration universelle des droits de l'homme	Dignité de toute personne ; droit à un niveau de vie suffisant, y compris l'alimentation (article 25)
1964	Déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale (révisée plusieurs fois, dernière version 2024)	Principes éthiques de la recherche médicale : protocole, avis d'un comité, consentement, intérêt de la personne avant celui de la science
1979	Rapport Belmont (États-Unis), publié après l'étude de Tuskegee	Trois principes pour la recherche : respect des personnes, bienfaisance, justice
1979	Beauchamp et Childress, *Principles of Biomedical Ethics*	Les quatre principes (6.3.2)
1983	Création du Comité consultatif national d'éthique (CCNE) en France	Avis sur les questions éthiques posées par la biologie, la médecine et la santé
1988	Loi Huriet-Sérusclat	Premier cadre français des recherches biomédicales
2002	Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades	Information, consentement, accès au dossier (6.3.9)
2012	Loi Jardé, appliquée depuis novembre 2016	Cadre actuel des recherches impliquant la personne humaine (6.3.12)

L'étude de **Tuskegee** (Alabama, 1932-1972) a suivi des hommes noirs atteints de syphilis sans les informer de leur maladie et sans les soigner, même après la découverte de la pénicilline. Son arrêt en 1972, après sa révélation par la presse, a conduit au rapport Belmont.

En nutrition aussi, des expériences ont été menées sans consentement réel. Au Canada, des enfants autochtones de pensionnats ont été soumis, entre 1942 et 1952, à des expériences nutritionnelles en situation de sous-alimentation ; ces faits ont été documentés par l'historien Ian Mosby en 2013. Ces exemples rappellent que les personnes les plus **vulnérables** (enfants, personnes pauvres, minorités) sont les premières exposées aux abus, et que la protection doit être plus forte pour elles.

Lien diététique – Ce que l'histoire change pour votre pratique

Un questionnaire distribué en atelier n'a rien à voir avec ces expériences. Pourtant, les mêmes principes s'appliquent à petite échelle : informer, laisser libre de participer, ne pas exposer les personnes à un risque inutile, protéger les plus fragiles. Le **respect** de ces règles est ce qui rend la confiance possible entre le public et les professionnels.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.2

Associez chaque principe actuel à un événement historique qui l'explique : a) le consentement libre et éclairé ; b) l'avis d'un comité avant une recherche ; c) l'attention particulière aux personnes vulnérables.

Corrigé

a) Le Code de Nuremberg (1947), rédigé après les expériences menées dans les camps nazis. b) La Déclaration d'Helsinki (1964) et, en France, la loi Huriet-Sérusclat (1988) puis la loi Jardé (2012). c) L'étude de Tuskegee et les expériences nutritionnelles sur des enfants autochtones au Canada, qui visaient des personnes sans pouvoir de refus.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.1 – Morale, éthique, déontologie, droit

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la différence entre la morale et l'éthique ?
2. Pourquoi la déontologie peut-elle aller au-delà du droit ? Donnez un exemple.
3. Quel courant éthique juge une action d'après ses conséquences ? Citez un auteur.
4. Complétez la formule de Kant : traiter l'humanité « toujours comme une fin, et … ».
5. Quel texte de 1947 a fait du consentement volontaire une exigence absolue ?
6. Qu'est-ce que l'étude de Tuskegee a montré ?

Corrigé – Point d'étape 6.3.1

1. La morale est un ensemble de valeurs et de normes souvent vécues comme évidentes ; l'éthique est une réflexion critique sur ces valeurs face à une situation concrète.
2. La déontologie fixe des devoirs propres à une profession, qui peuvent être plus exigeants que la loi : par exemple, se former en continu ou refuser une publicité qui serait légale.
3. Le conséquentialisme (utilitarisme) ; Jeremy Bentham ou John Stuart Mill.
4. « … jamais simplement comme un moyen ».
5. Le Code de Nuremberg.
6. Des personnes vulnérables ont été suivies sans être informées ni soignées : la recherche ne doit jamais passer avant l'intérêt des personnes, et les plus fragiles doivent être protégées.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.2.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux des courants éthiques et des repères historiques.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.1 et je refais les exercices d'application.

6.3.2 Les principes éthiques

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 6.2.2)

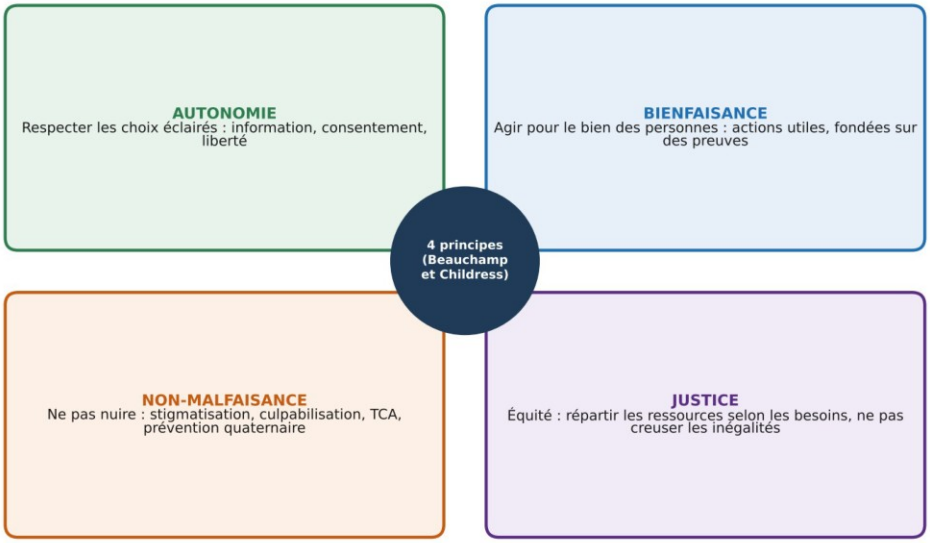


Figure 6.2 – Les quatre principes de l'éthique biomédicale

Comprendre le schéma – Figure 6.2

1. Autonomie : respecter la capacité des personnes à décider pour elles-mêmes, ce qui suppose une **information** claire (chapitre 5) et un **consentement** libre ; en santé publique, cela signifie ne pas imposer, ne pas manipuler, laisser le choix de participer.

2. Bienfaisance : agir pour le bien des personnes, avec des actions **utiles** et **fondées sur des preuves** (une action inefficace mobilise des ressources et du temps des participants).

3. Non-malfaisance (*primum non nocere*) : ne pas nuire ; en nutrition, les risques sont la **stigmatisation** du poids, la **culpabilisation**, l'induction de **restriction** ou de TCA, la médicalisation excessive (prévention quaternaire, chapitre 1).

4. Justice : répartir équitablement les ressources et les efforts selon les **besoins**, sans creuser les inégalités (universalisme proportionné, chapitre 2).

5. Ces principes, proposés par Beauchamp et Childress (*Principles of Biomedical Ethics*, 1979), ne se hiérarchisent pas a priori : la réflexion éthique consiste à les **arbitrer** dans chaque situation.

Les principes propres à la santé publique

La santé publique agit sur des **populations** et peut limiter certaines libertés (taxer, interdire, réglementer). Childress et ses collègues (2002) proposent cinq conditions pour justifier une action qui restreint les libertés :

Condition	Question à se poser
Efficacité	L'action a-t-elle des chances raisonnables d'atteindre son objectif de santé ?
Proportionnalité	Les bénéfices attendus l'emportent-ils sur les atteintes aux libertés et les effets négatifs ?
Nécessité	N'existe-t-il pas un moyen moins contraignant d'obtenir le même résultat ?
Moindre atteinte	Choisit-on la modalité la moins intrusive (information avant interdiction) ?
Justification publique	Les décideurs expliquent-ils publiquement et de façon transparente leurs choix ?

L'échelle d'intervention

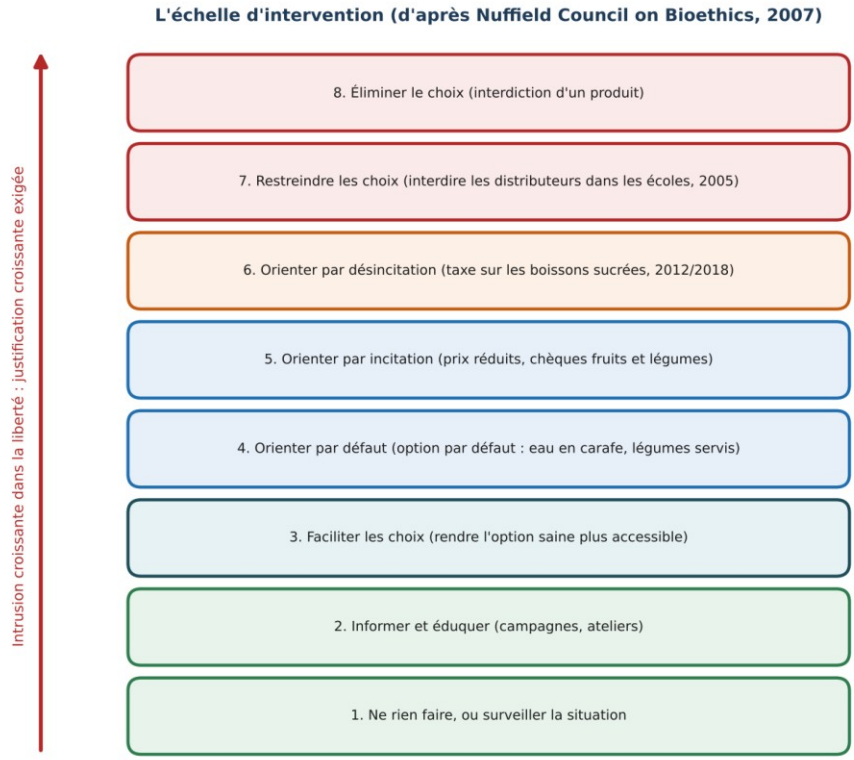


Figure 6.3 – L'échelle d'intervention en santé publique

Comprendre le schéma – Figure 6.3

1. Le Nuffield Council on Bioethics (2007) classe les interventions de santé publique selon leur degré d'**intrusion** dans la liberté individuelle, de « ne rien faire » à « éliminer le choix ».

2. Bas de l'échelle : informer, éduquer, faciliter (ateliers, campagnes PNNS) ; peu intrusifs, mais souvent moins efficaces seuls et plus favorables aux personnes déjà favorisées.

3. Milieu : orienter par défaut (*nudge* : légumes servis d'office, eau en carafe), inciter (chèques fruits et légumes), désinciter (contribution sur les boissons sucrées créée en 2012, rendue progressive selon la teneur en sucre en 2018, relevée le 1er mars 2025).

4. Haut de l'échelle : restreindre (interdiction des distributeurs automatiques payants dans les établissements scolaires depuis le 1er septembre 2005) ou éliminer le choix.

5. Plus on monte, plus la **justification** exigée est forte (gravité du problème, efficacité, absence d'alternative). Le diététicien de terrain agit surtout dans les échelons 2 à 4 ; il peut **argumenter** en faveur de mesures plus contraignantes auprès des décideurs (plaidoyer).

Définition – Nudge (« coup de pouce »)

Modification de l'**architecture du choix** qui oriente les comportements de manière prévisible **sans interdire** aucune option ni modifier significativement les incitations financières (Thaler et Sunstein, *Nudge*, 2008). Exemples : placer les fruits à hauteur des yeux au self, servir l'eau en carafe, rendre l'option végétarienne visible. On parle de **paternalisme libéral**.

Attention – Les questions éthiques posées par les nudges

Un nudge agit souvent **sans que la personne en ait conscience** : est-ce respectueux de son autonomie ? Les conditions d'un usage éthique sont la **transparence** (on peut annoncer la démarche : « Nous mettons les fruits en avant »), la **réversibilité** (la personne garde tous les choix), la **finalité** de santé (et non commerciale)

et l'**équité** (le nudge ne doit pas pénaliser un groupe).

Stigmatisation, culpabilisation et responsabilité individuelle

Les messages de nutrition peuvent produire des effets indésirables :

- **Stigmatisation du poids** (« grossophobie ») : images de personnes obèses sans visage, vocabulaire de la « lutte contre l'obésité » visant les personnes, moqueries. Elle est associée à une moins bonne santé mentale, à l'évitement des soins et à une prise de poids accrue ; elle est contraire au principe de non-malfaisance.
- **Culpabilisation** : faire porter la responsabilité aux individus (« Il suffit de manger mieux ») alors que les déterminants sont largement sociaux et environnementaux (chapitre 2).
- **Moralisation** de l'alimentation : « bons » et « mauvais » aliments, « tricher », « craquer » ; ces mots favorisent la restriction cognitive (chapitre 4).

Méthode pas à pas – Communiquer sans stigmatiser : 6 réflexes

1. Parler de **comportements** et d'**environnements**, pas de « personnes obèses » (dire « personnes en situation d'obésité » si nécessaire).
2. Utiliser des **images respectueuses** (personnes de toutes corpulences, actives, avec un visage).
3. Valoriser le **plaisir** et la **santé** plutôt que la minceur.
4. Ne jamais commenter le poids d'une personne devant un groupe ; ne pas peser en public.
5. Éviter le vocabulaire moral (bon/mauvais, interdit, tricher).
6. Rappeler les **déterminants** collectifs et proposer des solutions accessibles.

Méthode : analyser une action avec les quatre principes

Les quatre principes ne sont pas une liste à réciter. Ils servent à **examiner une action** sous quatre angles, puis à repérer les **tensions** entre eux. La méthode suivante peut être utilisée pour toute question de l'épreuve E5 qui demande d'« analyser les enjeux éthiques ».

Méthode pas à pas – Analyser une action en quatre angles

1. Décrire l'action en une phrase : qui fait quoi, pour qui, avec quels moyens.

2. Autonomie : les personnes sont-elles informées ? Sont-elles libres de participer, de refuser, de choisir ? Ont-elles été associées à la conception ?

3. Bienfaisance : l'action répond-elle à un besoin identifié par un diagnostic ? Est-elle fondée sur des preuves ? Quels bénéfices concrets en attendre ?

4. Non-malfaisance : quels effets indésirables sont possibles (stigmatisation, culpabilité, restriction, coût, perte de temps, atteinte à la vie privée) ? Comment les réduire ?

5. Justice : qui en profite et qui en est exclu ? L'action réduit-elle ou creuse-t-elle les inégalités (horaires, langue, coût, numérique) ?

6. Nommer la tension principale et proposer un **ajustement** qui la réduit.

Exemple – Analyse rédigée : des « paniers fruits et légumes » sur ordonnance

Action : une maison de santé (exemple fictif) propose à 40 familles orientées par les médecins un panier hebdomadaire de fruits et légumes à 2 € pendant six mois, avec trois ateliers cuisine.

- **Autonomie** : les familles choisissent d'entrer dans le dispositif et peuvent en sortir ; mais le contenu du panier est imposé. Ajustement : proposer deux tailles de paniers et une liste de légumes à éviter.
- **Bienfaisance** : l'action répond à un frein connu (le prix des fruits et légumes) ; les dispositifs d'ordonnances de fruits et légumes ont montré des hausses de consommation dans plusieurs évaluations,

à vérifier localement par un questionnaire avant et après.

- **Non-malfaisance** : le mot « ordonnance » peut médicaliser l'alimentation et faire sentir aux familles qu'elles « mangent mal ». Ajustement : parler de « panier de saison » et éviter tout discours sur le poids.
- **Justice** : l'orientation par les médecins oublie les familles qui ne consultent pas ; on peut ajouter une orientation par le centre social et l'épicerie solidaire.
- **Tension principale** : la justice (cibler les familles les plus modestes) contre la non-malfaisance (ne pas les désigner). Ajustement : un dispositif ouvert à tous, avec un tarif modulé selon le quotient familial (universalisme proportionné, chapitre 2).

Appliquer les conditions de Childress pas à pas

Les cinq conditions de Childress (6.3.2) s'appliquent aux mesures qui **restreignent** les choix. Il faut les examiner dans l'ordre, car si une mesure n'est pas efficace, il est inutile d'aller plus loin.

Condition	Mesure étudiée : supprimer les desserts sucrés le midi dans un self d'entreprise (exemple fictif)	Verdict
Efficacité	La mesure réduit les sucres consommés au self, mais les salariés peuvent acheter des desserts ailleurs	Douteuse
Proportionnalité	Atteinte forte au plaisir et au choix pour un gain incertain	Non remplie
Nécessité	D'autres moyens existent : fruits mis en avant, portions plus petites, desserts maison moins sucrés	Non remplie
Moindre atteinte	Un étiquetage clair et un dessert fruitier au prix le plus bas sont moins intrusifs	Non remplie
Justification publique	La direction n'a pas consulté les salariés ni expliqué ses raisons	Non remplie

Conclusion : la suppression n'est pas justifiée. On lui préfère une combinaison de mesures moins intrusives (bas et milieu de l'échelle d'intervention), évaluées au bout de trois mois.

Exemple – Calcul : estimer l'effet d'une mesure avant de la juger

Dans le self, 420 desserts sont vendus chaque jour, dont 30 % de fruits. La direction teste pendant un mois une présentation des fruits en premier, au prix le plus bas. La part des fruits passe à 41 %.

- Fruits vendus avant : 420 × 0,30 = **126** ; après : 420 × 0,41 = **172,2**, soit environ 172.
- Hausse relative : (41 − 30) / 30 × 100 = **36,7 %**.
- Desserts sucrés évités : 172 − 126 = **46** par jour, soit 46 × 20 jours = **920** par mois.

Ce résultat obtenu sans rien interdire rend la suppression des desserts encore moins nécessaire (condition de nécessité).

À vous de jouer – Exercice d'application 6.3

Une commune envisage d'interdire les camions de restauration rapide à moins de 200 mètres des collèges. Appliquez les cinq conditions de Childress en une phrase chacune, puis donnez votre avis argumenté.

Corrigé

Efficacité : la mesure réduit l'accès immédiat, mais les élèves peuvent marcher un peu plus loin ; l'effet doit être évalué. **Proportionnalité** : l'atteinte touche surtout des commerçants, pour un bénéfice possible chez les adolescents. **Nécessité** : on peut d'abord améliorer l'offre de la cantine et des foyers. **Moindre atteinte** : une charte avec les commerçants (offre de fruits, d'eau, de formules moins grasses) est moins intrusive. **Justification publique** : la commune doit présenter ses données, concerter commerçants, parents et élèves et

prévoir une évaluation. Avis : la mesure peut se défendre si elle s'accompagne d'une amélioration de la restauration scolaire et d'une concertation ; seule, elle risque d'être peu efficace et mal acceptée.

Liberté individuelle et protection de la santé : jusqu'où aller ?

La santé publique cherche à protéger la santé de tous, ce qui peut entrer en conflit avec la liberté de chacun. Ce débat est ancien. Dans *De la liberté* (1859), John Stuart Mill pose le **principe de non-nuisance** : la seule raison légitime de limiter la liberté d'une personne est d'empêcher qu'elle nuise à autrui. Selon ce principe, l'État ne devrait pas empêcher un adulte de manger ce qu'il veut, puisque cela ne nuit qu'à lui-même.

Trois arguments sont souvent opposés à cette position en nutrition :

- les choix alimentaires ne sont pas entièrement **libres** : ils sont fortement influencés par le marketing, le prix, l'offre disponible et les conditions de vie (chapitre 2) ;
- les maladies liées à l'alimentation ont un **coût collectif** (Assurance maladie, perte de productivité) ;
- les **enfants** ne peuvent pas exercer pleinement leur autonomie et doivent être protégés.

Type de paternalisme	Définition	Exemple en nutrition	Discussion
Paternalisme fort	Imposer un choix à une personne informée et capable, pour son bien	Interdire à un adulte d'acheter des sodas	Atteinte forte à l'autonomie, rarement justifiable
Paternalisme faible	Intervenir quand le choix n'est pas vraiment libre ou éclairé	Encadrer la publicité destinée aux enfants	Généralement accepté, car il protège des personnes vulnérables
Paternalisme libéral (« libertarien »)	Orienter les choix sans en supprimer aucun	Nudge : légumes en début de ligne de self	Accepté s'il est transparent et facile à contourner (6.3.2)

Définition – Principe de précaution

Principe selon lequel, lorsqu'un dommage grave et irréversible est possible, l'absence de certitude scientifique ne doit pas retarder l'adoption de mesures proportionnées pour le prévenir. En France, il figure à l'article 5 de la Charte de l'environnement (2004), qui a valeur constitutionnelle. En alimentation, il a par exemple justifié la suspension du bisphénol A dans les contenants alimentaires (loi du 24 décembre 2012).

Le principe de précaution ne signifie pas « interdire tout ce qui n'est pas prouvé sans danger ». Il impose des mesures **proportionnées** et **provisoires**, accompagnées de recherches pour réduire l'incertitude. Il ne faut pas le confondre avec la **prévention**, qui porte sur un risque connu et démontré (le sel et l'hypertension artérielle, par exemple).

Attention – Un argument souvent mal utilisé

Sur les réseaux sociaux, la « précaution » est parfois invoquée pour déconseiller des aliments sans fondement (« par précaution, évitez tous les produits laitiers »). Ce n'est pas le principe de précaution : celui-ci suppose un dommage grave plausible, identifié par une évaluation scientifique, et une réponse proportionnée décidée par les autorités. Un conseil d'éviction sans preuve peut au contraire nuire (carences, coût, anxiété).

À vous de jouer – Exercice d'application 6.4

Classez chaque mesure selon le type de paternalisme (fort, faible, libéral) et dites si elle vous paraît justifiable : a) interdiction de la publicité pour des produits gras, sucrés, salés pendant les programmes pour enfants ; b) carafe d'eau posée d'office sur les tables du restaurant universitaire, sodas toujours disponibles au comptoir ; c) obligation pour les adultes de suivre un atelier nutrition pour obtenir une aide alimentaire.

Corrigé

a) Paternalisme faible : il protège des enfants, plus sensibles à la publicité ; justifiable. b) Paternalisme libéral (nudge) : le choix reste entier et la mesure est transparente ; justifiable. c) Paternalisme fort : il impose une action à des adultes capables et conditionne une aide vitale ; il porte atteinte à l'autonomie et à la dignité (6.3.9) et n'est pas justifiable. On peut proposer l'atelier librement.

La stigmatisation du poids : un enjeu de santé, pas seulement de politesse

En 2020, un groupe de 36 experts internationaux a publié dans la revue *Nature Medicine* une **déclaration de consensus** pour mettre fin à la stigmatisation de l'obésité (Rubino et al., 2020). Ce texte rappelle que les préjugés sur le poids reposent souvent sur une idée fausse : l'obésité serait seulement une question de volonté individuelle (« il suffit de manger moins et de bouger plus »). Or le poids dépend de nombreux facteurs biologiques, génétiques, psychologiques, sociaux et environnementaux.

La stigmatisation a des **conséquences** documentées par de nombreuses études : évitement des consultations et des dépistages, moins bonne qualité des soins, dépression, faible estime de soi, isolement, et paradoxalement davantage de comportements alimentaires désordonnés et de prise de poids. Elle est donc contraire au principe de **non-malfaisance**, et elle est inefficace.

Au lieu de dire ou de faire	Préférer	Pourquoi
« Les obèses »	« Les personnes en situation d'obésité »	La personne n'est pas réduite à sa maladie
« La lutte contre l'obésité »	« La prévention », « favoriser une alimentation de qualité »	On lutte contre des causes, pas contre des personnes
Images de ventres sans visage	Personnes de toutes corpulences, actives, avec un visage	Respect de la dignité
Pesée devant le groupe	Pesée éventuelle en privé, seulement si elle est utile	Vie privée, non-malfaisance
« Manque de volonté »	Parler des déterminants et des conditions de vie	Information exacte et non culpabilisante
Matériel inadapté (fauteuils étroits, brassard trop petit)	Matériel adapté à toutes les corpulences	Accessibilité et justice

La stigmatisation peut aussi venir des **professionnels de santé** eux-mêmes, souvent sans qu'ils en aient conscience. Des études menées auprès de médecins, d'infirmiers et d'étudiants en nutrition montrent des préjugés implicites sur le poids. Le diététicien doit donc examiner ses propres représentations, par exemple en analyse de pratique.

Lien diététique – Stigmatisation et autres caractéristiques

La stigmatisation ne concerne pas que le poids. Les personnes en situation de précarité (« elles ne savent pas gérer leur budget »), les personnes d'origine étrangère (« leur cuisine est trop grasse ») ou les personnes âgées (« à son âge, ce n'est plus la peine ») sont aussi exposées. Le même réflexe s'applique : parler des conditions et des comportements, valoriser les savoir-faire, et ne jamais juger les personnes.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.5

Réécrivez ces trois phrases d'un support d'atelier pour qu'elles ne stigmatisent pas : a) « Les enfants obèses doivent arrêter de grignoter. » b) « Avec un peu de volonté, tout le monde peut perdre du poids. » c) « Les familles pauvres achètent trop de produits transformés. »

Corrigé

a) « Des repas et un goûter à heures régulières aident tous les enfants à avoir faim au bon moment. » b) « Le poids dépend de nombreux facteurs. Des petits changements choisis par la personne, accompagnés par un professionnel, sont plus efficaces que les régimes. » c) « Quand le budget est serré, les produits transformés sont souvent les moins chers et les plus rapides. Voici trois recettes simples, rapides et économiques. »

La posture professionnelle : un savoir-être

Le guide de 2025 relie l'éthique à la **posture professionnelle**, c'est-à-dire à la manière d'être du diététicien avec les personnes et le groupe. Elle se traduit par quatre valeurs, que l'on peut observer en atelier :

Valeur (guide 2025)	Ce que l'on observe chez le professionnel
Équité	Il adapte l'effort aux besoins : plus de temps ou d'aide pour ceux qui en ont besoin (universalisme proportionné, chapitre 2)
Justice sociale	Il veille à ce que l'action n'augmente pas les écarts : prix, horaires, langue, accès sans numérique
Bienveillance	Il accueille sans juger, valorise les savoirs des participants, évite toute parole stigmatisante sur le poids ou les habitudes
Autonomie individuelle et de groupe	Il propose sans imposer, laisse le groupe décider de ses règles et de ses objectifs, respecte un refus

Le savoir-être se travaille comme une compétence : on s'observe (enregistrement d'une animation avec accord), on demande un retour à un pair ou au tuteur, et on note dans un journal les situations qui ont posé question.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.2 – Les principes éthiques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre principes de Beauchamp et Childress.
2. Dans quel ordre examine-t-on les cinq conditions de Childress, et pourquoi commence-t-on par l'efficacité ?
3. Quelle est la différence entre un paternalisme fort et un nudge ?
4. Quelle est la différence entre principe de précaution et prévention ?
5. Citez deux conséquences de la stigmatisation du poids sur la santé.
6. Une part de fruits passe de 25 % à 35 % des desserts. Calculez la hausse relative.

Corrigé – Point d'étape 6.3.2

1. Autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice.
2. Efficacité, proportionnalité, nécessité, moindre atteinte, justification publique ; une mesure inefficace ne peut pas être justifiée, il est donc inutile d'examiner la suite.
3. Le paternalisme fort impose un choix à une personne capable ; le nudge oriente sans rien interdire et reste facile à contourner.
4. La précaution concerne un risque grave mais incertain ; la prévention concerne un risque connu et démontré.
5. Évitement des soins, dépression, faible estime de soi, comportements alimentaires désordonnés, prise de poids.
6. (35 − 25) / 25 × 100 = 40 %.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.3.

Mon score	Ce que je fais
3 ou 4 sur 6	Je relis la méthode des quatre angles et le tableau du paternalisme.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.2 et je refais les exercices d'application.

6.3.3 Le cadre professionnel du diététicien

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Essentiels M1 S2 §2 (p. 11)

Une profession réglementée

Texte	Contenu
Article L. 4371-1 CSP	Définition de la profession : le diététicien dispense des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l'éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients ; il contribue à la qualité de l'alimentation en collectivité et aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition
Articles L. 4371-2 et suivants CSP	Le titre est réservé aux titulaires des diplômes reconnus (BTS Diététique et nutrition, DUT/BUT génie biologique option diététique, diplômes européens autorisés)
Enregistrement	Enregistrement obligatoire des diplômes auprès de l'ARS (répertoire des professionnels de santé) avant tout exercice
Usurpation de titre	L'usage du titre de diététicien sans diplôme est un délit (renvoi à l'article 433-17 du Code pénal)
Code de déontologie	Charte de déontologie du diététicien-nutritionniste publiée par l'Association française des diététiciens nutritionnistes (AFDN), version du 1er janvier 2018 ; il n'existe pas d'ordre professionnel des diététiciens, le code engage les professionnels qui s'y réfèrent et sert de référence en cas de litige

Attention – « Nutritionniste », « coach »… des titres non protégés

Le titre de « nutritionniste » seul n'est pas protégé (sauf « médecin nutritionniste ») et de nombreux « coachs en nutrition » ou « naturopathes » diffusent des conseils sans qualification reconnue. En santé publique, le diététicien s'assure que les intervenants d'un projet ont les **compétences** requises et que les messages sont **fondés sur des preuves**.

Les grands devoirs déontologiques

Devoir	Traduction en santé publique
Respect de la personne	Dignité, non-discrimination (origine, religion, poids, handicap, revenus), bienveillance, respect des choix
Secret professionnel	Ne pas divulguer ce qui a été confié ou observé ; confidentialité dans les groupes
Compétence et mise à jour	Agir dans son champ de compétence ; formation continue ; veille scientifique et réglementaire
Indépendance	Refuser toute influence commerciale sur ses messages ; déclarer ses liens d'intérêts
Information loyale	Messages exacts, sourcés, sans promesse trompeuse ; pas de publicité mensongère
Orientation	Orienter vers le médecin ou un autre professionnel quand la situation dépasse son champ (TCA, pathologie)

Devoir	Traduction en santé publique
Confraternité et coopération	Travailler en équipe pluriprofessionnelle, respecter les autres professionnels

Neutralité et laïcité

Dans un service public (école, collectivité, hôpital), les agents publics sont tenus à une stricte **neutralité** religieuse et politique ; le stagiaire qui intervient dans ces structures adopte la même réserve. Les usagers, eux, sont libres de leurs convictions : le diététicien **respecte** les pratiques alimentaires religieuses (chapitre 4) sans les promouvoir ni les juger.

Titre protégé, champ de compétence et travail en équipe

La profession de diététicien est protégée par son **titre** : seules les personnes titulaires d'un diplôme reconnu et enregistrées peuvent se dire diététiciennes ou diététiciens. En revanche, le Code de la santé publique ne réserve pas aux diététiciens le monopole de tout conseil alimentaire : un médecin, un infirmier ou un enseignant peut parler d'alimentation dans son propre champ. C'est pourquoi la vigilance porte surtout sur l'**usage du titre** et sur la **qualité** des conseils diffusés.

Situation	Qui peut le faire ?	Point de vigilance
Animer un atelier de prévention « bien manger à petit prix »	Diététicien, mais aussi d'autres professionnels formés (conseillère en économie sociale et familiale, infirmière)	Messages conformes aux repères officiels
Établir un régime pour une pathologie (insuffisance rénale, diabète)	Diététicien, sur prescription médicale, ou médecin	Le diagnostic et la prescription relèvent du médecin
Se présenter comme « diététicien »	Seulement le titulaire d'un diplôme reconnu et enregistré	L'usurpation du titre est un délit
Prendre en charge seul une anorexie mentale sévère	Personne seul : prise en charge pluriprofessionnelle (médecin, psychiatre, diététicien, psychologue)	Orienter rapidement, l'anorexie mentale peut mettre la vie en danger

Le diététicien travaille dans son **champ de compétence**. Quand une situation le dépasse (suspicion de trouble du comportement alimentaire, perte de poids inexpliquée, signes de dénutrition grave, détresse psychique), il **oriente** vers le médecin traitant ou vers une structure spécialisée, et il le fait avec l'accord de la personne.

> **Définition – Développement professionnel continu (DPC)**
>
> Obligation, pour tous les professionnels de santé, de suivre un parcours de formation continue sur une période de trois ans, comprenant des actions de formation, d'évaluation des pratiques et de gestion des risques. Elle a été instituée par la loi du 21 juillet 2009 et réorganisée par la loi du 26 janvier 2016. Pour le diététicien, elle traduit le devoir déontologique de **compétence** et de mise à jour.

Le devoir de non-discrimination

L'article 225-1 du Code pénal définit la discrimination comme une distinction opérée entre les personnes sur le fondement de critères interdits, parmi lesquels l'origine, le sexe, l'apparence physique, l'état de santé, le handicap, la religion, la situation de famille, le lieu de résidence ou la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique. Refuser un service à une personne pour l'un de ces motifs est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (article 225-2).

En santé publique, la discrimination peut être **directe** (refuser une personne en situation d'obésité dans un atelier sportif) ou **indirecte** : une règle en apparence neutre qui désavantage un groupe (des inscriptions uniquement en ligne écartent les personnes sans accès au numérique). Le diététicien doit repérer les deux.

Exemple – Repérer une discrimination indirecte par le calcul

Un programme d'ateliers « cuisine et santé » (exemple fictif) accepte les inscriptions uniquement sur un site internet. Dans le quartier, 18 % des adultes n'ont pas d'accès personnel à internet. Parmi les 50 inscrits, aucun n'est dans ce cas.

- Si les inscriptions étaient indépendantes de l'accès à internet, on attendrait environ 50 × 0,18 = **9** inscrits sans accès personnel.
- On en observe **0** : le mode d'inscription a très probablement exclu ce public.

Ajustement : inscriptions aussi par téléphone, à l'accueil du centre social et par les travailleurs sociaux.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.6

Pour chaque situation, dites s'il s'agit d'une discrimination directe, indirecte, ou d'aucune discrimination, et justifiez : a) un club refuse une adolescente dans son atelier « sport et nutrition » à cause de son poids ; b) les ateliers d'une maison de quartier ont lieu uniquement à 10 h en semaine ; c) un atelier pour diabétiques est réservé aux personnes diabétiques.

Corrigé

a) Discrimination directe, fondée sur l'apparence physique ou l'état de santé. b) Discrimination indirecte possible : l'horaire écarte les personnes qui travaillent ; il faut proposer d'autres créneaux. c) Pas de discrimination : la distinction répond à un objectif légitime (l'éducation thérapeutique d'une maladie) et elle est proportionnée ; on peut ouvrir l'atelier aux aidants.

La déontologie au quotidien : huit situations commentées

Les devoirs déontologiques (6.3.3) prennent tout leur sens dans des situations concrètes. Le tableau suivant reprend des questions fréquentes en stage et en début d'exercice. Les réponses proposées sont des repères, à adapter avec le tuteur et l'équipe.

Situation	Devoir en jeu	Conduite proposée
1. Une participante offre une boîte de chocolats à la fin du cycle d'ateliers	Désintéressement, relation professionnelle	Un petit cadeau symbolique peut être accepté et partagé avec l'équipe ; un cadeau de valeur ou de l'argent est refusé avec tact
2. Un ami vous demande sur un réseau social « le meilleur régime pour perdre 10 kg »	Information loyale, pas de conseil individualisé sans bilan	Répondre en privé que vous ne pouvez pas conseiller sans bilan et l'orienter vers son médecin ou une consultation
3. Une collègue diffuse une fiche contenant une erreur (seuil de sel faux)	Compétence, confraternité, sécurité du public	Lui en parler en privé, avec la source, et proposer de corriger ensemble ; informer le responsable si l'erreur n'est pas corrigée
4. Une prescription médicale vous paraît inadaptée (régime sans sel strict chez une personne âgée qui mange peu)	Coopération, sécurité, non-malfaisance	Contacter le médecin pour en discuter, avec des arguments (risque de dénutrition) ; ne pas modifier seul la prescription
5. Un participant demande si vous pouvez lui vendre des compléments	Indépendance, absence de conflit d'intérêts	Refuser ; s'il a un besoin réel, l'orienter vers son médecin ou son pharmacien

Situation	Devoir en jeu	Conduite proposée
6. On vous propose d'animer un atelier sur un thème que vous maîtrisez mal (nutrition du sportif de haut niveau)	Compétence	Se former avant, ou orienter vers un collègue spécialisé
7. Une personne refuse vos conseils et veut continuer un régime très restrictif	Autonomie, non-malfaisance	Expliquer les risques avec des mots simples, laisser la porte ouverte, informer le médecin si un danger est possible et avec son accord
8. Vous êtes fatigué et irrité face à un groupe agité	Respect de la personne, maîtrise de soi	Faire une pause, rappeler le cadre calmement, en parler ensuite en analyse de pratique

Astuce – Trois questions à se poser avant d'agir

1. **Est-ce légal ?** (Code de la santé publique, Code pénal, RGPD, règlement de la structure).
2. **Est-ce conforme à ma déontologie ?** (secret, indépendance, compétence, respect).
3. **Serais-je à l'aise si ma décision était connue de la personne concernée, de mon tuteur ou du public ?** Si la réponse à l'une des questions est « non » ou « je ne sais pas », je m'arrête et je demande conseil.

La relation avec les autres professionnels

Le diététicien ne travaille presque jamais seul. En santé publique, il collabore avec des médecins, des infirmiers, des travailleurs sociaux, des enseignants, des animateurs, des cuisiniers et des élus. La **confraternité** et la **coopération** imposent de respecter les compétences de chacun, de ne pas dénigrer un autre professionnel devant le public, et de transmettre les informations utiles dans le respect du secret (6.3.4).

Lien diététique – Le diététicien et le cuisinier

Dans un projet de restauration collective, le cuisinier n'est pas un simple exécutant : il connaît les contraintes de production, les goûts des convives et le budget. Une démarche éthique consiste à construire les menus **avec** lui, à valoriser son savoir-faire et à expliquer les raisons des recommandations, plutôt qu'à imposer des fiches techniques. C'est aussi une condition de réussite du projet.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.7

Lors d'un atelier, une participante vous dit : « Mon médecin m'a dit n'importe quoi, il ne connaît rien à la nutrition. » Rédigez votre réponse en respectant la confraternité, sans nier ce qu'elle ressent.

Corrigé

Exemple : « J'entends que vous n'êtes pas satisfaite de ce qui vous a été dit. Je ne peux pas juger une consultation à laquelle je n'ai pas assisté. Si vous le voulez, nous pouvons noter ensemble vos questions pour que vous les posiez à votre médecin, ou je peux, avec votre accord, prendre contact avec lui pour que nous travaillions ensemble. » La réponse ne dénigre pas le médecin, reconnaît l'émotion de la personne et propose une coopération.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.3 – Le cadre professionnel

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. La profession de diététicien est-elle protégée par un monopole d'exercice ou par son titre ?
2. Qu'est-ce que le développement professionnel continu, et sur quelle période s'organise-t-il ?

3. Donnez un exemple de discrimination indirecte dans une action de santé publique.
4. Quelle conduite adopter face à une prescription médicale qui vous paraît inadaptée ?
5. Citez les trois questions à se poser avant d'agir.
6. Un atelier compte 40 inscrits ; 25 % du public visé ne lit pas le français, mais aucun inscrit n'est dans ce cas. Combien en attendrait-on ?

Corrigé – Point d'étape 6.3.3

1. Par son titre : l'usage du titre sans diplôme est un délit.
2. Une obligation de formation continue pour tous les professionnels de santé (formation, évaluation des pratiques, gestion des risques), organisée sur trois ans.
3. Inscriptions uniquement en ligne, horaires uniquement en journée, supports uniquement écrits en français.
4. Contacter le médecin pour en discuter avec des arguments, sans modifier seul la prescription.
5. Est-ce légal ? Est-ce conforme à ma déontologie ? Serais-je à l'aise si ma décision était connue ?
6. 40 × 0,25 = 10 inscrits.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.4.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau des huit situations et la partie sur la discrimination.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.3 et je refais les exercices d'application.

6.3.4 Le secret professionnel et la confidentialité

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Essentiels M1 S2 §2 (p. 11) ; Essentiels M1 S6 §2.1 et §2.2 (p. 22 et 23)

Définition – Secret professionnel

Obligation, pour un professionnel, de ne pas révéler les informations à caractère secret dont il a connaissance dans l'exercice de sa profession. Toute personne prise en charge par un professionnel ou un établissement de santé a droit au **respect de sa vie privée et du secret** des informations la concernant (article **L. 1110-4** du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002). La révélation d'une information à caractère secret est punie d'**un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende** (article **226-13** du Code pénal).

Situation en action collective	Conduite à tenir
Un participant confie en atelier un diagnostic (diabète)	L'information reste dans le groupe (règle de confidentialité énoncée au départ) ; le diététicien n'en parle pas à l'extérieur
Le partenaire demande « qui a des problèmes de poids »	Ne transmettre que des données agrégées et anonymes (« 8 participants sur 12 souhaitent… »)
Un parent confie des difficultés financières	Ne pas en parler devant le groupe ; proposer en privé une orientation (CCAS, épicerie solidaire) avec son accord
Un enfant semble en danger (signes de maltraitance, de négligence grave)	Le secret ne s'oppose pas à la protection de l'enfance : en parler sans délai au responsable de la structure ; information préoccupante à la cellule départementale (CRIP), ou 119 ; en cas de danger immédiat, 17
Échange avec l'équipe	Partage limité aux informations strictement nécessaires à la prise en charge, entre professionnels de l'équipe, la personne étant informée (article L. 1110-4 CSP)

Méthode pas à pas – Poser le cadre de confidentialité en début de séance

« Ici, chacun parle de ce qu'il veut. Ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe. Personne n'est obligé de répondre ou de goûter. On ne juge pas ce que mangent les autres. » Le cadre est rappelé à chaque séance et affiché si besoin.

Ce que couvre le secret, et ses exceptions

Le secret professionnel couvre **tout ce qui est venu à la connaissance** du professionnel dans l'exercice de sa profession : ce qui lui a été **confié**, mais aussi ce qu'il a **vu, entendu ou compris**. Il couvre aussi le fait même qu'une personne a consulté ou participé à un atelier. Sa violation est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (article 226-13 du Code pénal).

Le secret appartient à la **personne**, pas au professionnel. Il protège sa vie privée et la confiance nécessaire à la relation d'aide. C'est pourquoi la personne peut, dans certains cas, autoriser le partage d'informations, alors que le professionnel ne peut pas décider seul de les révéler.

Le secret couvre	Exemples en action collective
Les informations confiées	Un participant dit qu'il a un diabète, qu'il est au chômage, qu'il a des dettes
Les informations observées	Une participante semble très amaigrie ; un enfant arrive chaque semaine sans goûter
Les informations déduites	La présence d'une personne à un atelier « diabète » révèle sa maladie
L'identité des personnes accompagnées	Le nom des familles orientées par l'épicerie solidaire

Les dérogations prévues par la loi

Le secret n'est pas absolu. La loi prévoit des situations où le professionnel **doit** ou **peut** parler.

Type de dérogation	Exemples	Texte
Obligation de déclarer	Maladies à déclaration obligatoire (dont la toxi-infection alimentaire collective), déclaration de naissance ou de décès	Code de la santé publique
Permission de signaler	Privations ou sévices infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger ; violences au sein du couple quand elles mettent la vie de la victime en danger immédiat et qu'elle est sous emprise	Article 226-14 du Code pénal
Obligation d'agir face à un péril	Porter secours à une personne en danger (appeler les secours)	Article 223-6 du Code pénal (non-assistance à personne en danger)
Partage avec l'équipe	Échange des informations strictement nécessaires entre professionnels qui prennent en charge la même personne, celle-ci étant informée et pouvant s'y opposer	Article L. 1110-4 du Code de la santé publique

Le signalement fait de **bonne foi** dans le cadre de l'article 226-14 ne peut pas entraîner de sanction pour le professionnel. Ne rien faire face à un enfant en danger, en revanche, peut engager sa responsabilité (non-assistance à personne en danger).

Attention – Discrétion n'est pas secret

Le stagiaire, l'animateur ou le bénévole d'une association ne sont pas toujours soumis au secret professionnel au sens du Code pénal. Ils sont en revanche tenus à la **discrétion** et à la **confidentialité** par leur convention,

leur contrat ou le règlement de la structure. En pratique, la conduite attendue est la même : ne rien divulguer de ce qui a été appris sur les personnes, sauf pour les protéger.

Exemple – Le secret à la sortie de l'atelier

À la sortie d'un atelier, la voisine d'une participante vous demande : « Alors, Mme D. vient pour son diabète, c'est ça ? » La bonne réponse ne confirme ni n'infirme : « Je ne peux pas parler des personnes qui participent aux ateliers. Si vous voulez des informations sur les ateliers, je vous donne la plaquette. » Répondre « non, ce n'est pas pour ça » serait déjà une indiscrétion.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.8

Pour chaque situation, dites si vous devez parler, si vous pouvez parler, ou si vous devez vous taire : a) quatre participants d'un même buffet présentent des vomissements le lendemain ; b) un employeur appelle pour savoir si son salarié suit bien les ateliers ; c) une participante âgée et isolée semble privée de nourriture par son entourage.

Corrigé

a) Devoir de parler : suspicion de toxi-infection alimentaire collective, déclaration obligatoire à l'ARS, par le responsable de la structure ou le médecin. b) Se taire : l'employeur n'a pas à connaître la participation de son salarié, sauf accord de ce dernier. c) Pouvoir parler, et même agir : l'article 226-14 permet de signaler des privations infligées à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger ; en pratique, on en parle sans délai au responsable et on recherche l'accord de la personne, puis on alerte les services compétents (médecin traitant, services du département, procureur en cas de danger grave).

Partager des informations dans une équipe et en réseau

Un projet de santé publique réunit souvent des professionnels de plusieurs secteurs : santé, social, éducation, associations. Tous n'ont pas le même cadre. Le partage d'informations obéit à trois règles simples : la **personne est informée**, on partage **le strict nécessaire**, et **seulement** avec les professionnels qui en ont besoin pour l'aider.

Cadre	Qui peut partager ?	Conditions
Équipe de soins (article L. 1110-4 et L. 1110-12 du Code de la santé publique)	Professionnels qui participent directement à la prise en charge d'une même personne (médecin, infirmier, diététicien, psychologue…)	Informations strictement nécessaires à la continuité des soins ; personne informée, qui peut s'y opposer
Hors équipe de soins (entre secteur sanitaire et secteur social, par exemple)	Professionnels de santé et professionnels du social ou du médico-social	Consentement préalable de la personne
Action sociale (article L. 121-6-2 du Code de l'action sociale et des familles)	Professionnels de l'action sociale qui interviennent auprès d'une même personne ou famille	Partage limité à ce qui est nécessaire, personne informée ; information du maire dans certains cas
Protection de l'enfance (article L. 226-2-2 du même code)	Professionnels de la protection de l'enfance	Partage dans l'intérêt de l'enfant, parents informés sauf si c'est contraire à l'intérêt de l'enfant

Méthode pas à pas – Avant de transmettre une information sur une personne

1. Pourquoi ? Quel est le but précis de la transmission ? Est-il dans l'intérêt de la personne ?

2. À qui ? Le destinataire en a-t-il besoin pour l'aider ? Est-il lui-même tenu au secret ou à la discrétion ?

3. Quoi ? Quelle est l'information minimale utile ? (« Mme L. a besoin d'une aide pour ses courses » plutôt que tout son dossier).

4. Avec quel accord ? La personne est-elle informée ? A-t-elle donné son accord quand il est nécessaire ?

5. Comment ? Par un moyen sécurisé (messagerie sécurisée de santé, entretien en face à face), jamais par une messagerie personnelle ou un groupe de discussion.

6. Trace : noter la transmission dans le dossier ou le journal de bord, sans détail inutile.

Exemple – Une réunion de synthèse dans un centre social

Le centre social réunit chaque mois la conseillère en économie sociale et familiale, l'animatrice, la référente famille et la stagiaire diététicienne. On y parle d'une famille en difficulté. La stagiaire sait, par un entretien, que la mère saute des repas pour nourrir ses enfants. Avant la réunion, elle lui a demandé : « Est-ce que je peux en parler à la conseillère, pour qu'elle voie avec vous une aide alimentaire ? » La mère a accepté. En réunion, la stagiaire dit seulement : « Mme R. a des difficultés pour nourrir toute la famille et elle est d'accord pour qu'on l'aide à accéder à l'épicerie solidaire. » Le reste de l'entretien n'est pas répété.

Attention – Les groupes de discussion sur téléphone

Les échanges entre collègues sur des applications de messagerie grand public (groupes de discussion) sont pratiques, mais ils ne sont pas sécurisés et les messages peuvent être lus, transférés ou capturés. On n'y écrit jamais le nom d'une personne accompagnée ni une information sur sa santé ou sa situation. Pour les professionnels de santé, il existe des messageries sécurisées de santé (espace de confiance MSSanté).

À vous de jouer – Exercice d'application 6.9

L'enseignante d'une école demande à la diététicienne d'un atelier parents-enfants « ce que la mère de Lucas a dit sur ses repas à la maison », car Lucas s'endort souvent en classe. Indiquez la conduite à tenir en appliquant les six étapes de la méthode.

Corrigé

Pourquoi ? L'enseignante s'inquiète pour Lucas, son objectif est légitime. **À qui ?** L'enseignante n'est pas dans l'équipe de soins, et les propos de la mère ont été tenus dans un cadre confidentiel. **Quoi ?** Rien du contenu de l'atelier ne peut être transmis sans accord. **Accord** : la diététicienne peut proposer à la mère d'en parler elle-même avec l'enseignante, ou de rencontrer ensemble l'infirmière scolaire. **Comment ?** Si la mère accepte, un échange en face à face, limité à ce qu'elle souhaite partager. **Trace** : noter la demande et la réponse dans le journal de bord. Si la diététicienne observe des signes de danger pour Lucas, elle en parle au responsable de la structure (information préoccupante).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.4 – Le secret professionnel

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Le secret couvre-t-il seulement ce qui a été confié ? Justifiez.
2. À qui appartient le secret ?
3. Quelle sanction prévoit l'article 226-13 du Code pénal ?
4. Que permet l'article 226-14 du Code pénal ?
5. Quelles sont les trois règles du partage d'informations dans une équipe ?
6. Pourquoi ne faut-il pas écrire le nom d'une personne accompagnée dans un groupe de discussion grand

public ?

Corrigé – Point d'étape 6.3.4

1. Non : il couvre aussi ce qui a été vu, entendu ou compris, et le fait même que la personne a été accompagnée.
2. À la personne accompagnée.
3. Un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
4. De signaler, sans être sanctionné, les privations ou sévices infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger.
5. La personne est informée ; on partage le strict nécessaire ; seulement avec les professionnels qui en ont besoin pour l'aider.
6. Ces messageries ne sont pas sécurisées : les messages peuvent être lus, transférés ou capturés, ce qui viole le secret et le RGPD.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.5.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux des dérogations et du partage d'informations.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.4 et je refais les exercices d'application.

6.3.5 La protection des données personnelles (RGPD)

Module · Référentiel : C3.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 6.2.2)

Le **Règlement général sur la protection des données** (règlement (UE) **2016/679** du 27 avril 2016), applicable depuis le **25 mai 2018**, complète en France la loi **Informatique et libertés** du 6 janvier 1978. Il s'applique dès qu'on collecte des **données personnelles** : nom, adresse, téléphone, photo, mais aussi poids, habitudes alimentaires associées à une personne identifiable. Le contrôle est assuré par la **CNIL**.

Définition – Donnée personnelle, donnée de santé, anonymisation

- **Donnée personnelle** : toute information se rapportant à une personne physique **identifiée ou identifiable**, directement (nom) ou indirectement (croisement âge + école + quartier).
- **Données de santé** : catégorie **particulière** (article 9 du RGPD) dont le traitement est en principe **interdit**, sauf exceptions (consentement explicite, prise en charge sanitaire, intérêt public…) ; poids, pathologies, allergies, régimes médicaux en font partie.
- **Pseudonymisation** : remplacement du nom par un code ; les données restent **personnelles** (on peut retrouver la personne avec la clé).
- **Anonymisation** : rendre **impossible**, de façon irréversible, toute réidentification ; les données anonymes ne relèvent plus du RGPD.

Figure 6.4 – Les six principes du RGPD

Comprendre le schéma – Figure 6.4

1. Licéité, loyauté, transparence : chaque traitement repose sur une **base légale** (consentement, mission d'intérêt public, intérêt légitime…) et les personnes sont **informées** (qui collecte, pourquoi, combien de temps, leurs droits).

2. Limitation des finalités : les données sont collectées pour un objectif précis (évaluer l'atelier) et ne sont pas réutilisées pour autre chose (prospection commerciale).

3. Minimisation : on ne collecte que ce qui est **nécessaire** ; un questionnaire de satisfaction n'a pas besoin du nom ni de la date de naissance.

4. Exactitude : données exactes et mises à jour.

5. Limitation de la conservation : durée définie à l'avance, puis suppression ou anonymisation.

6. Intégrité et confidentialité : sécurité (fichier protégé par mot de passe, accès limité, pas de partage sur une messagerie personnelle, destruction des questionnaires papier).

7. S'y ajoute la **responsabilité** (*accountability*) : le responsable du traitement (la structure) doit pouvoir **démontrer** sa conformité (registre des traitements).

Droits des personnes	Contenu
Information	Savoir qui traite ses données, pourquoi, combien de temps
Accès et rectification	Obtenir ses données, les faire corriger
Effacement	Obtenir la suppression dans certains cas
Opposition	S'opposer au traitement pour des raisons tenant à sa situation
Retrait du consentement	À tout moment, aussi facilement qu'il a été donné
Réclamation	Saisir la CNIL

Exemple – Calcul : l'ordre de grandeur des sanctions

Les amendes administratives peuvent atteindre **20 millions d'euros** ou **4 % du chiffre d'affaires annuel mondial**, le montant **le plus élevé** étant retenu (article 83 du RGPD). Pour une entreprise de restauration collective réalisant 300 M€ de chiffre d'affaires : 4 % × 300 = 0,04 × 300 = **12 M€** ; 12 M€ < 20 M€ → plafond applicable : **20 M€**. Pour un groupe réalisant 2 milliards d'euros : 0,04 × 2 000 = **80 M€** > 20 M€ → plafond : **80 M€**. Une association peut aussi être sanctionnée (rappel à l'ordre, amende, injonction).

Méthode pas à pas – Mentions d'information à placer sur un questionnaire

« Ce questionnaire est **anonyme**. Il sert uniquement à **évaluer** l'atelier « Bien manger, petit budget » du centre social des Tilleuls. Les réponses sont saisies par l'étudiante stagiaire, puis les questionnaires papier sont détruits ; le fichier est conservé jusqu'au [date], puis supprimé. Vous êtes libre de ne pas répondre. Contact : [référente du centre social]. »

Exemple – Calcul d'une date de suppression

Questionnaires recueillis le 31 mars 2028, conservation prévue « 3 mois après l'épreuve E5, prévue le 15 juin 2028 » : 15 juin + 3 mois = **15 septembre 2028**. La date est écrite dans la mention d'information et dans le registre de la structure, et une alerte est programmée dans l'agenda.

Choisir la bonne base légale

Tout traitement de données personnelles doit reposer sur l'une des **six bases légales** prévues par l'article 6 du RGPD. La base légale n'est pas un détail administratif : elle détermine les droits des personnes (par exemple, le droit de retirer son consentement n'existe que si le traitement repose sur le consentement).

Base légale (article 6)	Quand l'utiliser ?	Exemple dans un projet de nutrition
Consentement	La personne a un vrai choix et peut refuser sans conséquence	Inscription à une lettre d'information d'une association ; utilisation de photos
Contrat	Le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat avec la personne	Gestion des inscriptions payantes à un cycle d'ateliers
Obligation légale	Une loi impose le traitement	Conservation des factures ; déclaration d'une toxi-infection alimentaire collective
Sauvegarde des intérêts vitaux	Urgence vitale, la personne ne peut pas consentir	Transmettre une allergie aux secours lors d'un malaise
Mission d'intérêt public	Le traitement est nécessaire à une mission de service public	Enquête d'une mairie ou d'un hôpital sur la restauration de ses usagers
Intérêt légitime	Organismes privés, intérêt réel qui ne porte pas une atteinte excessive aux droits des personnes	Une association évalue la satisfaction de ses adhérents

Pour les **données de santé**, il faut en plus l'une des exceptions de l'article 9 : consentement **explicite**, prise en charge sanitaire ou sociale par un professionnel tenu au secret, intérêt public dans le domaine de la santé publique, recherche scientifique encadrée, etc.

Attention – Le consentement n'est pas toujours la bonne base

Dans un service public ou chez un employeur, la personne n'est souvent pas vraiment libre de refuser : son consentement n'est alors pas valable. Une commune qui réalise une enquête de restauration scolaire s'appuie plutôt sur sa **mission d'intérêt public**, tout en laissant les familles libres de répondre. À l'inverse, pour diffuser des photos ou envoyer des messages d'information, le consentement reste la base adaptée.

Méthode pas à pas – Construire la fiche d'un traitement pour le registre

Le registre des activités de traitement (article 30 du RGPD) décrit chaque traitement de la structure. Pour un questionnaire de diagnostic, la fiche comprend :

1. Nom du traitement et responsable : « Enquête goûters 2027 », service de restauration de la commune.

2. Finalité : connaître les goûters des enfants pour adapter les ateliers.

3. Base légale : mission d'intérêt public.

4. Catégories de personnes et de données : parents ; âge et classe de l'enfant, aliments du goûter ; pas de nom.

5. Destinataires : service de restauration uniquement ; résultats globaux diffusés.

6. Durée de conservation : papier détruit trois mois après saisie ; fichier supprimé au bout d'un an.

7. Sécurité : fichier protégé par mot de passe, accès limité à deux personnes, stockage sur le serveur de la commune.

8. Transferts hors de l'Union européenne : aucun.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.10

Indiquez la base légale la plus adaptée pour chaque traitement : a) un hôpital enregistre les allergies des patients pour adapter leurs repas ; b) une association de diététiciens envoie une lettre d'information mensuelle à des abonnés ; c) une cuisine centrale conserve les factures de ses fournisseurs ; d) une mairie interroge les seniors du portage de repas sur leur satisfaction.

Corrigé

a) Mission d'intérêt public ou prise en charge sanitaire (article 9 : soins par des professionnels tenus au secret). b) Consentement : chaque abonné s'inscrit et peut se désinscrire à tout moment. c) Obligation légale (règles comptables). d) Mission d'intérêt public ; la participation reste libre et les personnes sont informées.

Sécuriser les données au quotidien

La sécurité est souvent le point faible des petits projets. Les incidents les plus fréquents ne viennent pas de pirates informatiques, mais d'**erreurs humaines** : une clé USB perdue, un courriel envoyé au mauvais destinataire, un tableau partagé en accès public, un questionnaire oublié sur une table.

Risque	Mesure simple
Perte ou vol d'un ordinateur ou d'une clé USB	Chiffrer les fichiers, ne pas stocker de données de santé sur une clé personnelle
Accès non autorisé	Mot de passe robuste et différent pour chaque service ; accès limité aux personnes qui en ont besoin
Envoi au mauvais destinataire	Vérifier les adresses ; envoyer les fichiers protégés par mot de passe et transmettre le mot de passe par un autre canal
Partage trop large	Vérifier les droits d'accès des documents partagés en ligne ; pas de lien « accessible à toute personne disposant du lien » pour des données personnelles
Questionnaires papier	Urne fermée pour les recueillir, rangement dans une armoire fermée à clé, destruction au broyeur
Outil en ligne hébergé hors de l'Union européenne	Préférer un outil qui héberge les données dans l'Union européenne, ou vérifier les garanties prévues

Définition – Pseudonymisation par table de correspondance

Technique qui consiste à remplacer le nom de chaque personne par un code (P01, P02…) dans le fichier d'analyse, et à conserver à part, de façon sécurisée, la table qui relie les codes aux noms. Elle est utile quand on doit relier deux questionnaires d'une même personne (avant et après un atelier). La table est conservée

par une seule personne, puis détruite dès qu'elle n'est plus nécessaire : le fichier devient alors anonyme si aucune autre information ne permet de retrouver les personnes.

Exemple – Relier deux questionnaires sans nom

Pour comparer les réponses avant et après un cycle d'ateliers sans demander le nom, on peut utiliser un **code personnel** que chaque participant construit lui-même et retrouve facilement : par exemple, les deux premières lettres du prénom de sa mère, suivies du jour de son anniversaire (« MA14 »). L'animateur ne connaît pas la correspondance. Attention : ce code reste une donnée personnelle si le groupe est petit et si l'on peut deviner la personne ; on évite donc de le combiner avec des informations très précises.

En cas de violation de données

Une **violation de données** est un incident de sécurité qui entraîne la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisé à des données personnelles. Le responsable du traitement doit :

- **documenter** chaque violation dans un registre interne ;
- la **notifier à la CNIL** dans un délai de **72 heures** après en avoir pris connaissance, sauf si elle ne présente pas de risque pour les personnes (article 33 du RGPD) ;
- **informer les personnes** concernées sans tarder si la violation présente un risque élevé pour leurs droits (article 34).

Le stagiaire qui découvre une violation (fichier envoyé par erreur, clé perdue) prévient **immédiatement** son tuteur et le délégué à la protection des données de la structure : chaque heure compte pour respecter le délai.

Exemple – Calcul du délai de notification

Une animatrice s'aperçoit le jeudi 9 septembre 2027 à 16 h qu'un tableau contenant le nom et les allergies de 35 enfants a été envoyé à tous les parents d'une classe. La structure doit notifier la CNIL au plus tard 72 heures plus tard, soit le **dimanche 12 septembre 2027 à 16 h**. En pratique, la notification se fait dès le vendredi, en ligne, et les familles concernées sont informées, car il s'agit de données de santé d'enfants.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.11

Une stagiaire a perdu dans le bus, le lundi 4 octobre 2027 vers 18 h, une clé USB non chiffrée contenant les réponses nominatives de 48 seniors à un questionnaire sur leur appétit et leur poids. Indiquez : a) s'il s'agit d'une violation de données ; b) ce que la stagiaire doit faire ; c) la date limite de notification à la CNIL ; d) deux mesures pour éviter que cela se reproduise.

Corrigé

a) Oui : perte de données personnelles, dont des données de santé (poids, appétit), avec un accès possible par un tiers. b) Prévenir immédiatement son tuteur et le délégué à la protection des données, décrire précisément le contenu de la clé et les circonstances. c) Au plus tard le jeudi 7 octobre 2027 vers 18 h ; les personnes doivent aussi être informées en raison du risque élevé. d) Ne jamais transporter de données nominatives sur une clé personnelle ; chiffrer les fichiers ; pseudonymiser les réponses dès la saisie ; travailler sur le serveur de la structure.

Délégué à la protection des données et analyse d'impact

Le **délégué à la protection des données** (DPO, pour *data protection officer*) conseille la structure, contrôle le respect du RGPD et sert de contact pour les personnes et pour la CNIL. Sa désignation est **obligatoire** pour les autorités et organismes publics (communes, hôpitaux, établissements scolaires) et pour les organismes dont

l'activité principale les conduit à traiter des données sensibles, comme les données de santé, à grande échelle. Dans un projet, il est l'interlocuteur à consulter avant de lancer une enquête ou un outil numérique.

Une **analyse d'impact relative à la protection des données** (AIPD, article 35 du RGPD) est obligatoire quand un traitement est susceptible d'engendrer un **risque élevé** pour les droits des personnes. La CNIL a publié une liste de critères ; un traitement qui en remplit au moins deux doit en principe faire l'objet d'une AIPD.

Critère de la CNIL (extraits)	Exemple dans un projet de nutrition
Données sensibles ou à caractère hautement personnel	Données de santé, poids, troubles alimentaires
Personnes vulnérables	Enfants, patients, personnes âgées dépendantes, personnes précaires
Collecte à grande échelle	Application de suivi alimentaire proposée à toute une région
Croisement de données	Rapprochement des données d'achats et des données de santé
Usage innovant ou nouvelle technologie	Analyse automatique des photos de repas par intelligence artificielle
Suivi systématique	Bracelet connecté qui enregistre en continu l'activité physique

Exemple – Faut-il une analyse d'impact ?

Une maison de santé veut proposer aux patients diabétiques un carnet alimentaire en ligne, analysé automatiquement par un logiciel qui calcule les glucides. Critères remplis : données de santé, personnes vulnérables (patients), usage innovant (analyse automatique), suivi systématique. Avec quatre critères, une analyse d'impact est nécessaire avant le lancement. Elle décrit le traitement, évalue sa nécessité et sa proportionnalité, identifie les risques (fuite, erreur de calcul, accès par des tiers) et prévoit des mesures pour les réduire. L'hébergement des données de santé doit en outre être confié à un hébergeur certifié pour les données de santé (HDS).

Astuce – Le réflexe « minimisation » en trois questions

Avant d'ajouter une question à un questionnaire, demandez-vous : 1. Vais-je réellement utiliser cette réponse dans mon analyse ? 2. Puis-je obtenir la même information sous une forme moins précise (tranche d'âge plutôt que date de naissance, quartier plutôt qu'adresse) ? 3. Cette question peut-elle mettre la personne mal à l'aise ou la désigner ? Si la réponse à la première question est « non », supprimez la question.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.12

Transformez ces questions pour respecter la minimisation : a) « Date de naissance » ; b) « Adresse complète » ; c) « Poids et taille » dans un questionnaire de satisfaction sur des ateliers cuisine ; d) « Revenus exacts du foyer ».

Corrigé

a) « Tranche d'âge : moins de 25 ans, 25 à 44 ans, 45 à 64 ans, 65 ans et plus. » b) « Quartier » ou commune, seulement si l'analyse par quartier est prévue. c) Supprimer : ces données de santé sont inutiles pour évaluer la satisfaction. d) Supprimer, ou remplacer par une question facultative en grandes tranches (« Votre budget alimentaire par semaine : moins de 50 €, 50 à 100 €, plus de 100 € ») si l'analyse en a besoin.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.5 – Le RGPD

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez quatre des six bases légales de l'article 6 du RGPD.

2. Pourquoi le consentement n'est-il pas une base valable pour une enquête imposée par un employeur ?
3. Quelle différence y a-t-il entre pseudonymisation et anonymisation ?
4. Dans quel délai une violation de données doit-elle être notifiée à la CNIL ?
5. Une violation est découverte le mardi à 10 h. Quelle est la date limite de notification ?
6. Citez trois critères qui peuvent rendre une analyse d'impact obligatoire.

Corrigé – Point d'étape 6.3.5

1. Consentement, contrat, obligation légale, sauvegarde des intérêts vitaux, mission d'intérêt public, intérêt légitime.
2. Le salarié n'est pas vraiment libre de refuser, son consentement n'est donc pas libre.
3. Les données pseudonymisées restent personnelles, car on peut retrouver la personne avec la table de correspondance ; les données anonymisées ne permettent plus aucune réidentification.
4. 72 heures après en avoir pris connaissance.
5. Le vendredi à 10 h.
6. Données sensibles, personnes vulnérables, grande échelle, croisement de données, usage innovant, suivi systématique.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.6.
3 ou 4 sur 6	Je relis les bases légales et la partie sur la sécurité.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.5 et je refais les exercices d'application.

6.3.6 Le consentement et le droit à l'image

Module · Référentiel : C3.1, C3.5 · CNED : Essentiels M1 S6 §2.1 et §2.2 (p. 22 et 23)

Le consentement à participer

Participer à une action de santé publique est **libre** : on informe des objectifs, du déroulement, des éventuelles dégustations (allergènes), de l'usage des données ; on recueille un accord (souvent oral pour un atelier, écrit pour une enquête ou des photos). La personne peut se **retirer** à tout moment sans conséquence (elle garde l'accès aux autres services de la structure). Pour un **mineur**, l'accord des **titulaires de l'autorité parentale** est recherché, mais l'avis de l'enfant compte aussi (assentiment).

Attention – Recherche ou évaluation ?

Un questionnaire d'évaluation d'un atelier n'est pas une **recherche impliquant la personne humaine** au sens de la loi Jardé (loi du 5 mars 2012). Si l'objectif devient la production de **connaissances généralisables** (publication scientifique), un avis d'un **comité de protection des personnes** (CPP) peut être requis : demander conseil à l'équipe pédagogique.

Le droit à l'image

Définition – Droit à l'image

Chaque personne a le droit de s'opposer à la prise et à la diffusion de son image sans son autorisation, sur le fondement du respect de la **vie privée** (article **9 du Code civil**). Capter ou diffuser l'image d'une personne dans un lieu privé sans son consentement est puni par l'article 226-1 du Code pénal.

Élément de l'autorisation	Contenu attendu
Identité	Nom de la personne photographiée (et des représentants légaux pour un mineur)
Objet	Contexte de la prise de vue (atelier du 15 mars 2028)
Supports	Affiche, rapport de stage, dossier E5, site du centre social, réseaux sociaux (cocher chaque case séparément)
Durée et territoire	Durée de l'autorisation (exemple : 2 ans), lieu de diffusion
Gratuité	Mention de l'absence de rémunération
Retrait	Possibilité de retirer l'autorisation à tout moment pour l'avenir
Signature	Datée, par la personne majeure ou par les deux titulaires de l'autorité parentale pour un mineur (avec l'avis de l'enfant)

Astuce – Photos sans visage

Pour illustrer un dossier E5, privilégier des photos de **mains**, de **plats**, de **supports** ou de dos : on limite les risques, tout en conservant des preuves de l'action. Floutez les visages si l'autorisation manque.

Les quatre qualités d'un consentement valable

Le RGPD (article 4 et article 7) définit précisément ce qu'est un consentement valable. Ces exigences s'appliquent à l'utilisation de données et de photos ; elles sont aussi un bon repère pour la participation à une action.

Qualité	Ce que cela veut dire	Exemple conforme	Exemple non conforme
Libre	La personne peut refuser sans subir de conséquence	« Vous pouvez participer à l'atelier sans être photographié »	« Les photos sont obligatoires pour participer »
Spécifique	Un accord distinct pour chaque usage	Cases séparées : affiche, site, réseaux sociaux	Une seule case « j'accepte tout »
Éclairé	La personne sait qui, quoi, pourquoi, combien de temps, et ses droits	Note d'information claire, lue ou expliquée à l'oral	Formulaire juridique de deux pages en petits caractères
Univoque	Un acte positif clair	Case cochée par la personne, signature	Case cochée à l'avance, silence, inaction

Le consentement doit aussi être **retirable** à tout moment, aussi simplement qu'il a été donné, et la structure doit pouvoir **prouver** qu'il a été recueilli (formulaire signé, trace d'inscription).

Définition – Âge du consentement numérique en France

Pour l'inscription à des services en ligne (réseaux sociaux, applications) qui reposent sur le consentement, la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles a fixé l'âge du consentement à **15 ans** en France. En dessous, le consentement conjoint du mineur et du ou des titulaires de l'autorité parentale est nécessaire. Pour un projet qui propose une application ou un compte en ligne à des collégiens, il faut donc prévoir l'accord des parents.

Méthode pas à pas – Recueillir un consentement à l'oral dans un atelier

Pour les personnes qui lisent peu, le consentement peut être expliqué à l'oral, puis confirmé par une signature ou une croix devant témoin.

1. Dire le but : « Nous aimerions prendre quelques photos des plats et des mains pour l'affiche du centre social. »

2. Dire les usages : « L'affiche sera dans le hall pendant un an. Il n'y aura pas de photo sur internet. »

3. Dire la liberté : « Vous pouvez dire non, cela ne change rien pour l'atelier. Vous pouvez changer d'avis plus tard. »

4. Vérifier la compréhension : « Pouvez-vous me redire où la photo sera affichée ? » (le « faire dire », chapitre 5).

5. Recueillir l'accord : formulaire simplifié avec pictogrammes, signé ou marqué d'une croix.

6. Respecter le refus : signe discret (pastille sur le badge) pour que le photographe évite la personne.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.13

Un formulaire d'inscription à un atelier comporte la phrase suivante, avec une case déjà cochée : « J'accepte que mes données et mon image soient utilisées par l'association et ses partenaires. » Relevez quatre défauts au regard des qualités du consentement, puis réécrivez la partie du formulaire.

Corrigé

Défauts : la case est pré-cochée (consentement non univoque) ; données et image sont mélangées (non spécifique) ; les usages et les partenaires ne sont pas précisés (non éclairé) ; le lien avec l'inscription laisse penser que l'accord est obligatoire (non libre) ; rien n'est dit sur le retrait. Réécriture : « Photos (facultatif, cela ne change rien à votre inscription). J'accepte d'être photographié pendant l'atelier pour : [ ] l'affiche dans le hall du centre social ; [ ] le site internet du centre social ; [ ] le compte du centre social sur les réseaux sociaux. Durée : deux ans. Je peux retirer mon accord à tout moment auprès de l'accueil. Mes coordonnées ne sont transmises à aucun partenaire. »

Droit à l'image : cas particuliers et évolutions récentes

Le principe est simple : il faut l'**autorisation** de la personne pour capter et diffuser son image dès qu'elle est **reconnaissable**. Les tribunaux admettent quelques limites à ce principe, mais elles s'appliquent rarement aux actions de santé publique.

Situation	Autorisation nécessaire ?	Commentaire
Photo d'un atelier où l'on reconnaît les participants	Oui, de chaque personne reconnaissable	Autorisation écrite et spécifique pour chaque support
Vue d'ensemble d'une foule lors d'un forum public, sans personne isolée ou cadrée	En principe non	Dès qu'une personne est isolée ou mise en avant, il faut son accord
Personne photographiée de dos, sans signe distinctif	En principe non	Attention aux vêtements, tatouages ou lieux qui permettent de la reconnaître
Élu ou personnalité lors de l'inauguration publique du projet	Non pour l'information sur l'événement	L'image ne doit pas être détournée (publicité, montage)
Photo d'un enfant	Oui, accord des deux titulaires de l'autorité parentale et avis de l'enfant selon son âge	Loi du 19 février 2024 sur le droit à l'image des enfants
Image modifiée ou créée par intelligence artificielle à partir du visage d'une personne	Oui, et la diffusion sans accord d'un montage qui n'apparaît pas comme tel est sanctionnée	Article 226-8 du Code pénal, complété par la loi du 21 mai 2024 (sécurisation de l'espace numérique)

Définition – Le droit à l'image des enfants (loi du 19 février 2024)

Cette loi a inscrit dans le Code civil que les parents protègent **ensemble** le droit à l'image de leur enfant mineur, en l'associant selon son âge et son degré de maturité. En cas de désaccord entre les parents, le juge peut interdire à l'un d'eux de diffuser des images sans l'accord de l'autre. Elle rappelle que l'image d'un enfant relève de sa **vie privée**, y compris lorsqu'elle est publiée par ses propres parents.

Attention – Les images de corps et le « avant/après »

Même avec l'accord de la personne, la diffusion d'images de silhouettes « avant et après » une perte de poids pose un problème éthique : elle centre le message sur l'apparence, renforce la stigmatisation du poids et peut inciter des personnes vulnérables à des régimes dangereux. Une action de santé publique valorise plutôt les **comportements** (cuisiner, bouger, partager un repas) et le **plaisir**.

Combien de temps garder les photos ?

L'autorisation précise une **durée**. À la fin de cette durée, les images doivent être retirées des supports et supprimées des archives, sauf nouvelle autorisation. En pratique, on tient un **tableau de suivi** des photos : date, personnes représentées, supports autorisés, date de fin, date de retrait d'un accord éventuel.

Exemple – Calcul de la fin d'une autorisation

Photos prises lors d'un atelier le 22 mars 2027, autorisation « pour deux ans à compter de la prise de vue ». Date de fin : **22 mars 2029**. Une participante retire son accord le 10 janvier 2028 : ses photos sont retirées du site internet dès que possible et ne sont plus utilisées pour l'avenir ; l'affiche déjà imprimée et retirée du hall n'est pas réimprimée.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.14

Pour chaque photo prévue lors d'un forum santé en plein air, dites si une autorisation est nécessaire : a) une vue large du forum avec une centaine de visiteurs ; b) un gros plan d'une mère et de son enfant qui goûtent une soupe ; c) le maire qui coupe le ruban d'inauguration ; d) une photo de la mère et de l'enfant transformée par une application en dessin animé pour l'affiche de l'an prochain.

Corrigé

a) En principe non, si aucune personne n'est isolée ou mise en avant. b) Oui : autorisation de la mère et des deux titulaires de l'autorité parentale pour l'enfant, avec son avis selon son âge. c) Non pour illustrer l'événement ; l'image ne doit pas être détournée. d) Oui : même transformée, l'image reste celle de personnes reconnaissables, et la nouvelle utilisation (affiche de l'année suivante) doit être prévue dans l'autorisation.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.6 – Consentement et droit à l'image

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre qualités d'un consentement valable selon le RGPD.
2. Une case pré-cochée constitue-t-elle un consentement ? Justifiez.
3. À quel âge un mineur peut-il consentir seul à l'utilisation de ses données par un service en ligne en France ?
4. Que prévoit la loi du 19 février 2024 ?
5. Pourquoi les images « avant/après » posent-elles un problème même avec l'accord de la personne ?
6. Une autorisation de trois ans est signée le 5 mai 2027. Quelle est sa date de fin ?

Corrigé – Point d'étape 6.3.6

1. Libre, spécifique, éclairé, univoque.
2. Non : le consentement doit résulter d'un acte positif clair de la personne.
3. 15 ans.
4. Les deux parents protègent ensemble le droit à l'image de leur enfant mineur, en l'associant selon son âge et sa maturité.
5. Elles centrent le message sur l'apparence, renforcent la stigmatisation du poids et peuvent inciter à des régimes dangereux.
6. Le 5 mai 2030.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.7.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau des qualités du consentement et celui des cas particuliers.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.6 et je refais les exercices d'application.

6.3.7 Les conflits d'intérêts

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 6.2.2)

Définition – Conflit d'intérêts

Situation dans laquelle un **intérêt secondaire** (financier, professionnel, personnel) est susceptible d'influencer, ou de **paraître** influencer, le jugement d'un professionnel dans l'exercice de sa mission (**intérêt primaire** : la santé des personnes). Le lien d'intérêts n'est pas une faute en soi ; c'est son **absence de déclaration** et de **gestion** qui pose problème.

Situation	Analyse et gestion
Une marque de yaourts propose de financer les ingrédients d'un atelier en échange de son logo sur l'affiche	Risque de publicité et de perte d'indépendance ; refuser ou négocier : financement sans logo ni produit de marque, convention écrite, mention transparente du soutien, contenu décidé seul par le diététicien
Un fabricant de lait infantile offre des échantillons pour un atelier parents	À refuser : contraire au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (OMS, 1981), qui interdit la promotion auprès du public et des professionnels
Un supermarché local offre un bon d'achat aux participants	Acceptable si aucun produit n'est promu dans les messages, avec transparence ; préférer un partenariat avec l'épicerie solidaire ou le marché
Le diététicien a un cabinet et anime un atelier municipal	Ne pas faire la promotion de son cabinet pendant l'atelier ; donner une liste de plusieurs professionnels
Une association de producteurs fournit des supports pédagogiques	Vérifier l'exactitude et la neutralité ; citer la source ; préférer les supports institutionnels (Santé publique France)

Lien diététique – La transparence des liens d'intérêts

La loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (dite « loi Bertrand ») impose la publication des avantages et conventions entre les industries de santé et les professionnels de santé sur la base publique **Transparence Santé**. Les experts des agences (ANSES, HAS) remplissent une **déclaration publique d'intérêts**. Dans un projet, le diététicien peut appliquer la même logique : déclarer par écrit les partenariats et leur contenu.

Avantages, cadeaux et transparence : les règles

Deux dispositifs du Code de la santé publique encadrent les relations entre les professionnels de santé, dont les diététiciens, et les entreprises qui produisent ou commercialisent des produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux et autres produits listés par le Code de la santé publique). Pour les autres entreprises (agroalimentaire, compléments alimentaires), ces textes ne s'appliquent pas toujours, mais la déontologie conduit aux mêmes réflexes.

Dispositif	Principe	Ce que cela change pour le diététicien
Encadrement des avantages (dit « loi anti-cadeaux », 1993, refondu en 2017)	Les entreprises ne peuvent pas offrir d'avantages aux professionnels de santé, y compris aux étudiants qui se destinent à ces professions, sauf exceptions encadrées (rémunération d'une activité réelle, hospitalité raisonnable lors d'un congrès, dons pour la recherche) déclarées ou autorisées	Refuser les cadeaux, repas ou voyages offerts par un laboratoire en dehors de ce cadre
Transparence des liens (loi du 29 décembre 2011)	Les entreprises publient les conventions, les rémunérations et les avantages accordés aux professionnels, à partir de 10 €	Les liens du diététicien avec ces entreprises sont consultables par tous sur la base Transparence Santé

Ces règles ne sont pas une marque de méfiance envers les professionnels. Elles reposent sur un constat : même un petit cadeau crée un sentiment de **réciprocité** qui peut influencer le jugement, souvent sans que la personne en ait conscience.

Définition – Biais de réciprocité

Tendance à vouloir rendre ce que l'on a reçu. Un professionnel qui a reçu un échantillon, un repas ou un objet d'une marque aura tendance, sans le vouloir, à percevoir plus favorablement ses produits. C'est pourquoi la déontologie recommande de refuser les petits avantages et de déclarer tous les liens.

Méthode pas à pas – Gérer une sollicitation d'une entreprise

1. Identifier : qui propose quoi, en échange de quoi ? Quel est l'intérêt de l'entreprise ?

2. Vérifier le cadre : la proposition entre-t-elle dans les exceptions autorisées ? Faut-il une convention, une déclaration ?

3. Évaluer l'effet : le public pourrait-il penser que mes conseils sont influencés ? Le produit serait-il mis en avant ?

4. Décider : refuser, ou accepter sous conditions (convention écrite, absence de promotion, contenu choisi par moi).

5. Déclarer : mentionner le lien en début d'intervention, dans la déclaration d'intérêts et auprès de l'employeur.

6. Tracer : garder une copie de la convention et des échanges.

Exemple – Une invitation à un congrès

Un laboratoire pharmaceutique invite une diététicienne hospitalière à un congrès à l'étranger, transport et hôtel payés. Ce type d'hospitalité doit faire l'objet d'une convention entre l'entreprise et la professionnelle, soumise selon le montant à une déclaration ou à une autorisation préalable de l'instance compétente, et rester d'un niveau raisonnable, strictement lié à l'objet scientifique. La diététicienne informe son employeur.

L'avantage est ensuite rendu public sur la base Transparence Santé. Si elle intervient plus tard dans une formation sur la dénutrition, elle mentionne ce lien.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.15

Pour chaque proposition faite à une étudiante en BTS Diététique et nutrition, dites si elle peut l'accepter et à quelles conditions : a) un stylo et un carnet au logo d'un fabricant de lait infantile lors d'un salon ; b) un repas gratuit offert par un laboratoire pharmaceutique après une présentation de produits ; c) une rémunération pour animer un atelier dans une pharmacie, sur un thème choisi par elle, sans promotion de produits.

Corrigé

a) À refuser : avantage offert par une entreprise de produits de santé, et le Code international de l'OMS (1981) déconseille tout cadeau promotionnel des fabricants de substituts du lait maternel aux professionnels. b) À refuser : avantage sans contrepartie professionnelle réelle, interdit par l'encadrement des avantages, qui s'applique aussi aux étudiants. c) Possible : rémunération d'une activité réelle, avec une convention écrite, une liberté totale sur le contenu, aucune promotion et la mention du lien si elle intervient ensuite sur des sujets proches.

Le financement de la recherche en nutrition : un risque de biais

Les recommandations nutritionnelles reposent sur des études scientifiques. Or une partie de ces études est financée par des entreprises qui ont un intérêt commercial dans leurs résultats. Plusieurs travaux ont montré que ce financement est associé à des **conclusions plus favorables** aux produits de l'entreprise.

- En 2007, une analyse d'articles sur les boissons (sodas, jus, lait) publiée dans la revue *PLoS Medicine* (Lesser et al.) a montré que les articles entièrement financés par l'industrie avaient environ **quatre à huit fois plus de chances** d'aboutir à une conclusion favorable aux produits que les articles sans financement industriel.
- En 2016, des historiens ont publié dans la revue *JAMA Internal Medicine* (Kearns, Schmidt et Glantz) des documents montrant qu'une organisation de l'industrie sucrière avait financé, dans les années 1960, une revue scientifique qui minimisait le rôle du sucre dans les maladies cardiovasculaires et mettait l'accent sur les graisses, sans que ce financement soit déclaré.

Ces exemples ne signifient pas que toute étude financée par l'industrie est fausse. Ils montrent que le **financement doit être déclaré** et pris en compte dans la lecture critique.

Méthode pas à pas – Lire une étude de façon critique (financement et intérêts)

1. Qui a financé l'étude ? Chercher la rubrique « financement » (*funding*) en fin d'article.

2. Les auteurs ont-ils des liens d'intérêts ? Rubrique « conflits d'intérêts » (*competing interests*).

3. Le financeur a-t-il participé à la conception, à l'analyse ou à la rédaction ? Les bonnes revues l'exigent dans la déclaration.

4. Les résultats concordent-ils avec ceux d'autres études indépendantes ? Une étude isolée ne suffit pas à changer une recommandation.

5. Qui diffuse le résultat ? Un communiqué de presse d'une marque n'est pas une source scientifique.

Lien diététique – Pourquoi s'appuyer sur les avis des agences

Les avis de l'Anses, de l'EFSA ou du Haut Conseil de la santé publique reposent sur l'analyse de **l'ensemble des études** disponibles par des groupes d'experts qui déclarent publiquement leurs liens d'intérêts. Ils sont donc moins exposés au biais d'une étude isolée. Pour un support d'atelier, ce sont les sources à privilégier, avec la date de l'avis.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.16

Un participant vous montre un article de presse : « Une étude prouve que manger des céréales au chocolat chaque matin améliore la concentration des enfants. » L'étude, menée sur 40 enfants pendant deux semaines, a été financée par un fabricant de céréales. Rédigez trois questions critiques et une réponse adaptée au participant.

Corrigé

Questions : Qui a financé l'étude et a-t-il participé à l'analyse ? L'effectif (40 enfants) et la durée (deux semaines) permettent-ils une conclusion générale ? À quoi les céréales au chocolat ont-elles été comparées (absence de petit déjeuner ou autre petit déjeuner) ? D'autres études indépendantes trouvent-elles le même résultat ? Réponse : « Cette étude est petite et courte, et elle a été financée par le fabricant. Ce qu'on sait de façon solide, c'est qu'un petit déjeuner aide beaucoup d'enfants à tenir la matinée. Il peut être varié : pain, produit laitier, fruit. Les céréales au chocolat peuvent en faire partie de temps en temps. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.7 – Les conflits d'intérêts

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Les étudiants sont-ils concernés par l'encadrement des avantages ?
2. À partir de quel montant les avantages accordés à un professionnel de santé sont-ils publiés sur Transparence Santé ?
3. Qu'est-ce que le biais de réciprocité ?
4. Citez les six étapes de la gestion d'une sollicitation d'une entreprise.
5. Qu'a montré l'analyse publiée en 2007 dans *PLoS Medicine* sur les études concernant les boissons ?
6. Pourquoi privilégier les avis des agences sanitaires plutôt qu'une étude isolée ?

Corrigé – Point d'étape 6.3.7

1. Oui, les étudiants qui se destinent aux professions de santé sont concernés.
2. À partir de 10 €.
3. La tendance à vouloir rendre ce que l'on a reçu, qui peut influencer le jugement sans que l'on en ait conscience.
4. Identifier, vérifier le cadre, évaluer l'effet, décider, déclarer, tracer.
5. Les articles financés par l'industrie avaient environ quatre à huit fois plus de chances de conclure en faveur des produits.
6. Ils analysent l'ensemble des études disponibles, par des experts qui déclarent leurs liens d'intérêts.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.8.
3 ou 4 sur 6	Je relis la méthode de gestion d'une sollicitation et la partie sur la recherche.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.7 et je refais les exercices d'application.

6.3.8 Une démarche de réflexion éthique

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 6.2.2)

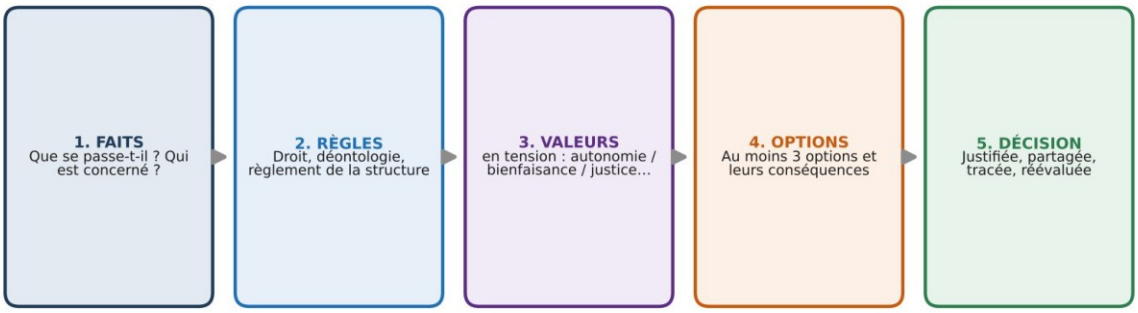


Figure 6.5 – Cinq étapes pour analyser un dilemme éthique

Comprendre le schéma – Figure 6.5

1. Faits : décrire la situation sans jugement ; qui est concerné, qu'est-ce qui pose question ?

2. Règles : qu'imposent le droit (secret, RGPD, droit à l'image), la déontologie, le règlement de la structure ?

3. Valeurs en tension : quels principes s'opposent (autonomie contre bienfaisance, justice contre efficacité) ?

4. Options : envisager au moins **trois** réponses possibles et leurs conséquences pour chaque personne concernée.

5. Décision : choisir l'option la plus juste, la **justifier**, la **partager** (tutrice, équipe), la **tracer** (journal de bord) et la réévaluer. Les situations complexes peuvent être portées devant un **espace de réflexion éthique régional** (ERER) ou le comité d'éthique d'un établissement ; au niveau national, le Comité consultatif national d'éthique (CCNE, créé en 1983) rend des avis.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.17

Une mère demande à Inès de « peser tous les enfants » de l'atelier goûters « pour qu'on sache lesquels sont trop gros ». Analysez la situation avec la grille en 5 étapes.

Corrigé

Faits : demande d'une mère ; enfants de 6 à 10 ans ; atelier collectif. **Règles** : données de santé (RGPD, consentement des deux parents), secret, l'atelier n'est pas une consultation. **Valeurs** : bienfaisance (s'inquiéter de la santé des enfants) contre non-malfaisance (stigmatisation, comparaison entre enfants) et autonomie (consentement des autres familles). **Options** : a) peser en public (rejetée : stigmatisant) ; b) refuser sans explication (rejetée : la préoccupation est légitime) ; c) expliquer pourquoi on ne pèse pas en atelier et orienter vers le médecin traitant ou la PMI/la santé scolaire pour le suivi de la courbe de corpulence. **Décision** : option c, en accord avec la tutrice, notée dans le journal de bord ; l'atelier reste centré sur le plaisir et les goûters.

Une analyse complète rédigée avec la grille en cinq étapes

L'exemple suivant montre le niveau de rédaction attendu à l'épreuve E5 pour une question du type « Analysez cette situation sur le plan éthique et proposez une conduite à tenir ».

Exemple – Les dons de viennoiseries à l'épicerie solidaire

Situation (fictive) : une épicerie solidaire reçoit chaque semaine d'un supermarché environ 60 kg de viennoiseries et de gâteaux arrivés à date limite. Une bénévole propose de les refuser : « On ne va pas donner du sucre aux pauvres. » Une autre répond : « Les familles adorent ça, et sinon ce sera jeté. » La responsable

vous demande votre avis.

1. Faits : 60 kg de produits sucrés et gras par semaine, gratuits, déjà produits ; des familles en situation de précarité, qui choisissent leurs produits ; un risque de gaspillage ; deux bénévoles en désaccord.

2. Règles : la loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire oblige les grandes surfaces à proposer leurs invendus encore consommables à des associations ; l'article L. 266-1 du Code de l'action sociale et des familles demande une aide alimentaire diversifiée, de qualité, et respectueuse de la dignité ; les règles d'hygiène imposent de respecter les dates et la chaîne du froid.

3. Valeurs en tension : bienfaisance (une alimentation favorable à la santé) contre autonomie (le libre choix des familles) ; justice (les familles modestes ont droit, comme les autres, au plaisir des viennoiseries) contre non-malfaisance (une offre très sucrée en grande quantité) ; lutte contre le gaspillage.

4. Options :

- a) Refuser tous ces dons : protège peut-être la santé, mais prive les familles d'un plaisir, traite les adultes comme incapables de choisir et augmente le gaspillage ;
- b) Tout accepter et tout mettre en rayon sans limite : respecte le choix, mais l'offre devient déséquilibrée et peut remplacer d'autres produits ;
- c) Accepter, proposer ces produits en libre choix avec une quantité raisonnable par passage, et redistribuer le surplus (accueils de jour, maraudes) ; parallèlement, négocier avec le supermarché des dons de fruits, de légumes et de produits laitiers, et proposer un atelier « goûters maison » sans obligation.

5. Décision : l'option c respecte l'autonomie et la dignité des familles, limite le gaspillage, et agit sur l'offre plutôt que sur les personnes. Elle est présentée à la responsable et aux bénévoles, inscrite au compte rendu de réunion, et évaluée au bout de trois mois (quantités distribuées, retours des familles, produits frais obtenus).

Méthode pas à pas – Rédiger une réponse éthique à l'écrit

1. Une phrase d'introduction qui nomme le dilemme : « Cette situation oppose le respect du choix des familles et la volonté de proposer une alimentation favorable à la santé. »

2. Un paragraphe par étape, avec un titre court (Faits, Règles, Valeurs, Options, Décision).

3. Des principes nommés (autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice) et des **textes datés** quand ils existent.

4. Au moins trois options, chacune avec un avantage et une limite.

5. Une décision justifiée par les principes, avec les modalités pratiques (qui, quand, comment) et une évaluation.

6. Une phrase de conclusion qui rappelle le partage de la décision avec l'équipe.

Astuce – Les connecteurs utiles pour argumenter

Pour opposer : « cependant », « en revanche », « à l'inverse ». Pour justifier : « en effet », « car », « puisque ». Pour conclure : « c'est pourquoi », « ainsi », « en conséquence ». Pour nuancer : « dans la mesure où », « à condition que », « sauf si ». Une argumentation éthique se reconnaît souvent à ses nuances.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.18

Un restaurant d'entreprise veut retirer la salière des tables sans prévenir les salariés. Rédigez la phrase d'introduction qui nomme le dilemme, puis les trois options avec un avantage et une limite pour chacune.

Corrigé

Introduction : « Cette situation oppose la réduction de la consommation de sel, utile pour la santé cardiovasculaire, et le respect de l'information et du choix des salariés. » Options : a) retirer les salières sans prévenir : peut réduire le sel ajouté, mais manque de transparence et risque de rejet ; b) laisser les salières et ne rien faire : respecte le choix, mais ne change rien ; c) réduire le sel dans les recettes progressivement, laisser une salière disponible au comptoir plutôt que sur chaque table, et expliquer la démarche par une affiche : réduit le sel tout en restant transparent et réversible, mais demande une concertation avec le chef cuisinier.

Les lieux de la réflexion éthique

Le professionnel n'est pas seul face à un dilemme. Plusieurs lieux permettent de partager la réflexion, du plus proche au plus institutionnel.

Niveau	Lieu	Rôle
Équipe	Réunion d'équipe, analyse de pratique, supervision	Discuter de situations vécues, prendre du recul, construire des réponses communes
Établissement	Comité ou espace de réflexion éthique d'un hôpital ou d'un établissement médico-social	Rendre des avis sur des situations complexes ou des questions générales (alimentation en fin de vie, contention, refus de soins)
Région	Espace de réflexion éthique régional (ERER)	Former, documenter, organiser des débats, soutenir les comités locaux
National	Comité consultatif national d'éthique (CCNE), créé en 1983	Rendre des avis publics sur les grandes questions éthiques de la biologie, de la médecine et de la santé ; organiser les états généraux de la bioéthique

Les avis de ces instances sont **consultatifs** : ils éclairent la décision, mais la responsabilité reste aux professionnels et aux personnes concernées.

Le journal de bord : tracer pour apprendre

Tenir un **journal de bord** des situations difficiles aide à prendre du recul et montre, à l'épreuve, que l'on a su mener une réflexion éthique. Il ne contient **aucune donnée identifiante** : on désigne les personnes par leur rôle (« une participante », « le père d'un enfant »).

Rubrique	Contenu (exemple)
Date et contexte	12 mars 2027, atelier cuisine parents-enfants, 8 participants
Situation	Un père a refusé que son fils goûte la recette contenant du porc, sans l'expliquer
Ce que j'ai fait	Proposé une variante sans porc préparée à part, sans commentaire devant le groupe
Principes en jeu	Respect des convictions, non-discrimination, sécurité (contamination croisée), discrétion
Ce que j'en retiens	Prévoir une variante dans chaque recette et le dire dès l'inscription
Avec qui j'en ai parlé	Ma tutrice, le 13 mars

Lien diététique – L'analyse de pratique en formation

En formation, l'analyse de pratique consiste à présenter une situation vécue en stage devant un petit groupe, avec un animateur, en respectant la confidentialité. Le groupe pose des questions pour comprendre, puis propose d'autres lectures de la situation. Cet exercice entraîne directement aux questions de l'épreuve E5 qui demandent de justifier une posture professionnelle.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.19

Rédigez une entrée de journal de bord pour la situation suivante, sans aucune donnée identifiante : pendant un atelier en EHPAD, une résidente vous a dit qu'elle ne mangeait plus le soir car « personne ne l'aide à couper sa viande ».

Corrigé

Date et contexte : atelier « plaisir de manger », 6 résidents. Situation : une résidente dit ne plus manger le soir faute d'aide pour couper sa viande. Ce que j'ai fait : je l'ai remerciée, je lui ai demandé si elle acceptait que j'en parle à l'équipe soignante ; elle a accepté ; j'ai transmis l'information à l'infirmière coordinatrice le jour même. Principes en jeu : bienfaisance (risque de dénutrition), autonomie (son accord), dignité (aide au repas), secret partagé. Ce que j'en retiens : demander systématiquement l'aide nécessaire au repas lors des ateliers ; proposer des textures adaptées. Avec qui j'en ai parlé : ma tutrice et l'infirmière coordinatrice.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.8 – La démarche de réflexion éthique

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez dans l'ordre les cinq étapes de la grille.
2. Combien d'options faut-il envisager au minimum, et pourquoi ?
3. Que prévoit la loi du 11 février 2016 pour les grandes surfaces ?
4. Quelle est la différence entre un comité d'éthique d'établissement et le CCNE ?
5. Pourquoi un journal de bord ne doit-il contenir aucune donnée identifiante ?
6. Citez deux connecteurs pour nuancer une argumentation.

Corrigé – Point d'étape 6.3.8

1. Faits, règles, valeurs en tension, options, décision.
2. Au moins trois, pour éviter un choix binaire (tout accepter ou tout refuser) et trouver une solution plus juste.
3. Elles doivent proposer leurs invendus encore consommables à des associations d'aide alimentaire.
4. Le comité d'établissement rend des avis sur des situations ou des questions locales ; le CCNE rend des avis publics nationaux sur les grandes questions éthiques.
5. Il pourrait être lu par d'autres personnes : il doit respecter le secret et le RGPD.
6. « Dans la mesure où », « à condition que », « sauf si ».

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.9.
3 ou 4 sur 6	Je relis l'exemple rédigé et la méthode de rédaction.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.8 et je refais les exercices d'application.

6.3.9 Les droits des usagers et la démocratie en santé

Module · Référentiel : C3.1 · CNED : Essentiels M1 S6 §1 (p. 22) ; Essentiels M1 S6 §2.1 et §2.2 (p. 22 et 23) ; Essentiels M1 S6 §2.3 (p. 23 et 24)

Les grands textes

Texte	Apports
Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), article 25	Droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être, notamment pour l'alimentation
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), article 11	Droit à une nourriture suffisante et droit fondamental d'être à l'abri de la faim
Loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale	Droits des personnes accueillies en établissement social ou médico-social : livret d'accueil, contrat de séjour, conseil de la vie sociale (CVS), projet personnalisé ; charte des droits et libertés de la personne accueillie (2003)
Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades	Information, consentement, accès au dossier, secret ; représentation des usagers dans les instances de santé
Loi EGalim (2018), article L. 266-1 du Code de l'action sociale et des familles	La lutte contre la précarité alimentaire vise à favoriser l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en situation de vulnérabilité, dans des conditions qui respectent leur dignité et développent leur capacité à agir
Loi de modernisation de notre système de santé (2016)	Renforcement de la démocratie sanitaire : conseils territoriaux de santé, médiation en santé

Définition – Démocratie en santé

Démarche qui associe les usagers, les citoyens et leurs représentants à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de santé, à travers des instances (conférences régionales de la santé et de l'autonomie, conseils territoriaux de santé, commissions des usagers à l'hôpital, conseils de la vie sociale dans les établissements médico-sociaux) et des démarches participatives.

Lien diététique – Ce que cela change pour un projet en établissement

Dans un EHPAD, un foyer ou un établissement pour personnes handicapées, un projet sur les repas gagne à être présenté au **conseil de la vie sociale** (représentants des résidents, des familles et du personnel), qui donne son avis sur l'organisation de la vie quotidienne, dont la restauration. C'est une exigence de respect des droits et un gage d'adhésion.

Attention – Dignité et aide alimentaire

La définition de la lutte contre la précarité alimentaire (EGalim) insiste sur la **dignité** et la **capacité à agir** : choix des produits (épiceries solidaires plutôt que colis imposés), participation financière symbolique quand c'est possible, accueil sans jugement, participation des bénéficiaires. Un atelier culinaire dans une structure d'aide alimentaire respecte ces principes : pas de leçon, valorisation des savoir-faire, liberté de participer.

Personne de confiance, directives anticipées et alimentation en fin de vie

Les droits des personnes malades prennent une importance particulière quand une personne ne peut plus exprimer sa volonté. Trois dispositifs du Code de la santé publique permettent de respecter son **autonomie** même dans cette situation.

Dispositif	Définition	Lien avec l'alimentation
Personne de confiance (loi du 4 mars 2002, élargie en 2015 au secteur médico-social)	Personne désignée par écrit (parent, proche, médecin traitant) qui accompagne le patient et témoigne de sa volonté s'il ne peut plus l'exprimer	Elle peut rappeler ce que la personne aimait, refusait ou souhaitait (convictions, goûts, volonté de ne plus être alimentée artificiellement)
Directives anticipées (loi du 22 avril 2005, renforcées par la loi du 2 février 2016)	Volontés écrites d'une personne majeure sur sa fin de vie, en particulier sur la poursuite, la limitation ou l'arrêt des traitements	Elles peuvent préciser le refus d'une nutrition artificielle (sonde, perfusion)
Procédure collégiale	Concertation de l'équipe soignante, avec avis d'un médecin extérieur, avant de limiter ou d'arrêter un traitement quand la personne ne peut pas s'exprimer	Elle porte sur la nutrition et l'hydratation artificielles, considérées comme des traitements

La loi du 2 février 2016 (dite loi Claeys-Leonetti) précise que la **nutrition et l'hydratation artificielles constituent des traitements**. Elles peuvent donc être limitées ou arrêtées lorsqu'elles apparaissent inutiles, disproportionnées ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, en respectant la volonté du patient ou, s'il ne peut l'exprimer, après une procédure collégiale. Les **soins de confort** (soins de bouche, petites quantités d'aliments plaisir proposés si la personne le souhaite) sont, eux, toujours assurés.

Attention – Ne pas confondre alimentation plaisir et nutrition artificielle

Proposer à une personne en fin de vie un yaourt, une glace ou quelques cuillères d'un plat qu'elle aime n'est pas un traitement : c'est un soin de confort qui respecte sa dignité. À l'inverse, forcer une personne à manger contre sa volonté n'est jamais acceptable. Le rôle du diététicien est d'adapter l'offre (textures, goûts, petites portions) au souhait de la personne.

Le refus alimentaire d'une personne âgée

En EHPAD ou à domicile, le refus de manger d'une personne âgée est une situation fréquente et difficile. Il peut avoir des causes **médicales** (douleur dentaire, troubles de la déglutition, dépression, effets de médicaments), **organisationnelles** (repas servis trop tôt, textures inadaptées, absence d'aide) ou exprimer une **volonté** (fin de vie, perte de sens).

Méthode pas à pas – Face à un refus alimentaire

1. Chercher une cause traitable avec l'équipe et le médecin : bouche, dents, déglutition, douleur, humeur, médicaments.

2. Adapter l'offre : plats aimés, textures, horaires, enrichissement, aide au repas, ambiance.

3. Écouter la personne : que dit-elle de son refus ? Que souhaite-t-elle ?

4. Associer la personne de confiance et la famille, sans leur transférer la décision.

5. Discuter en équipe de la conduite à tenir et la noter dans le dossier ; recourir au comité d'éthique si le désaccord persiste.

6. Respecter la volonté d'une personne capable et informée, tout en maintenant les soins de confort.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.20

M. V., 88 ans, résident d'un EHPAD, mange de moins en moins depuis un mois. Sa fille demande qu'on « le force à manger ». Indiquez trois causes à rechercher, deux adaptations de l'offre, et la réponse à faire à la fille.

Corrigé

Causes : problème dentaire ou prothèse mal adaptée, trouble de la déglutition, dépression, effet d'un médicament, douleur, constipation. Adaptations : plats qu'il aime, enrichissement des préparations, textures adaptées, fractionnement, aide au repas, horaires plus souples. Réponse : « Nous partageons votre inquiétude. Nous recherchons avec le médecin une cause qui pourrait être soignée et nous adaptons les repas à ses goûts. Forcer votre père à manger n'est pas possible : ce serait contraire à sa dignité, et cela peut être dangereux (fausse route). Nous aimerions savoir ce qu'il aimait et ce qu'il souhaitait : pouvons-nous en parler ensemble, avec lui si possible ? »

La participation des usagers à l'hôpital et dans les établissements

La démocratie en santé (6.3.9) se traduit par des instances où les usagers et leurs représentants donnent leur avis.

Instance	Où ?	Composition et rôle
Commission des usagers (CDU), qui a remplacé en 2016 la commission des relations avec les usagers	Établissements de santé	Représentants des usagers issus d'associations agréées, médiateurs, direction ; examine les plaintes et réclamations, propose des améliorations de l'accueil et de la prise en charge, y compris la restauration
Conseil de la vie sociale (CVS)	Établissements et services sociaux et médico-sociaux (EHPAD, foyers, centres d'hébergement)	Représentants des personnes accueillies, des familles et du personnel ; avis sur l'organisation de la vie quotidienne, dont les repas
Commission des menus	Restauration scolaire, EHPAD, hôpitaux (selon l'organisation)	Usagers, parents, cuisiniers, diététicien ; avis sur les menus et leur qualité
Conseil territorial de santé	Territoire de démocratie sanitaire	Élus, professionnels, usagers ; contribue au diagnostic territorial et au projet régional de santé

La **charte de la personne hospitalisée** (circulaire du 2 mars 2006) rappelle notamment le droit à une prise en charge respectueuse de la dignité et de l'intimité, et le droit d'exprimer des observations sur les soins et l'accueil, y compris sur les repas. Elle doit être affichée et remise aux patients.

Lien diététique – Les réclamations sur les repas : une source d'amélioration

Dans beaucoup d'établissements, les repas font partie des sujets de réclamation les plus fréquents (température, goût, choix, horaires). Pour un diététicien, analyser ces réclamations avec la commission des usagers est un moyen de construire un projet d'amélioration fondé sur la parole des usagers : enquête de satisfaction, test de nouvelles recettes, horaires du dîner plus tardifs, choix entre deux plats.

Exemple – Calcul : exploiter des réclamations

Sur une année, un hôpital (exemple fictif) a reçu 240 réclamations écrites, dont 54 concernent les repas. Parmi ces 54 : 23 sur la température des plats, 14 sur le goût, 11 sur l'absence de choix, 6 sur les horaires.

- Part des réclamations qui concernent les repas : 54 / 240 × 100 = **22,5 %**.
- Parmi elles, température : 23 / 54 × 100 = **42,6 %** ; goût : 14 / 54 × 100 = **25,9 %** ; choix : 11 / 54 × 100 = **20,4 %** ; horaires : 6 / 54 × 100 = **11,1 %**.

La température est la première cause : la priorité porte sur l'organisation de la distribution (chariots chauffants, délai entre la cuisine et le lit) plutôt que sur les recettes. Ces chiffres sont présentés à la

commission des usagers, qui suit l'évolution l'année suivante.

Le patient partenaire

Un **patient partenaire** (ou patient expert) est une personne qui vit avec une maladie chronique et qui, après une formation, met son expérience au service des autres patients et des équipes : co-animation d'ateliers d'éducation thérapeutique, participation à la conception de supports, formation des étudiants. Sa participation reconnaît le **savoir expérientiel** des patients, complémentaire du savoir des professionnels. Dans un projet de nutrition, il aide par exemple à vérifier qu'une fiche sur le diabète est compréhensible et réaliste.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.21

Dans un EHPAD de 80 résidents (exemple fictif), 30 résidents ou familles ont répondu à une enquête : 18 trouvent le dîner servi trop tôt (17 h 45), 9 trouvent les plats trop salés, 21 souhaitent un choix entre deux plats le soir. Calculez les pourcentages, indiquez à quelle instance présenter les résultats, et proposez une action prioritaire.

Corrigé

Dîner trop tôt : 18 / 30 = 60,0 % ; plats trop salés : 9 / 30 = 30,0 % ; souhait d'un choix : 21 / 30 = 70,0 %. Taux de réponse : 30 / 80 = 37,5 %, ce qui limite la représentativité. Instance : le conseil de la vie sociale, qui donne son avis sur l'organisation des repas, et la commission des menus. Action prioritaire : proposer un choix entre deux plats le soir et tester un dîner plus tardif (par exemple 18 h 30), en concertation avec l'équipe de cuisine et de soins ; mesurer ensuite la satisfaction et les quantités consommées.

Deux droits récents : le droit à l'oubli et l'action de groupe

- **Droit à l'oubli** (assurance des prêts) : une personne guérie d'un cancer ou d'une hépatite C n'a plus à le déclarer à l'assureur **5 ans** après la fin du protocole thérapeutique sans rechute (loi du 28 février 2022, dite loi Lemoine, applicable depuis le 1er juin 2022 ; auparavant 10 ans). La convention AERAS (« s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé ») organise l'accès au crédit pour les autres maladies.
- **Action de groupe** : créée en santé par la loi du 26 janvier 2016, elle a été remplacée par un **régime unique** par la loi du 30 avril 2025 (actions introduites depuis le 2 mai 2025). En santé, elle vise les manquements d'un producteur ou d'un fournisseur de produits de santé ; une association agréée d'usagers peut agir au nom de plusieurs victimes.
- **Loi HPST** (« Hôpital, patients, santé et territoires », 21 juillet 2009) : elle crée les agences régionales de santé (ARS) et les conférences régionales de la santé et de l'autonomie (CRSA), lieux d'expression des usagers.

Exemple – Le droit à l'oubli expliqué à une participante

Une participante d'un atelier, traitée pour un cancer du sein, a terminé son traitement en mars 2021 sans rechute. Pour un prêt demandé en octobre 2026, elle n'a plus à déclarer ce cancer : le délai de 5 ans est atteint en mars 2026. Le diététicien n'a pas à donner de conseil juridique, mais il peut l'orienter vers France Assos Santé ou la Ligue contre le cancer.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.9 – Droits des usagers

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel est le rôle de la personne de confiance ?
2. Que précise la loi du 2 février 2016 sur la nutrition et l'hydratation artificielles ?
3. Proposer quelques cuillères d'un plat aimé à une personne en fin de vie est-il un traitement ?
4. Citez trois causes possibles d'un refus alimentaire chez une personne âgée.

5. Quelle instance examine les réclamations des usagers à l'hôpital ?

6. Sur 150 réclamations, 36 concernent les repas. Calculez le pourcentage.

Corrigé – Point d'étape 6.3.9

1. Accompagner le patient et témoigner de sa volonté s'il ne peut plus l'exprimer.

2. Ce sont des traitements, qui peuvent être limités ou arrêtés s'ils sont inutiles ou disproportionnés, selon la volonté du patient ou après une procédure collégiale.

3. Non, c'est un soin de confort, toujours assuré si la personne le souhaite.

4. Problème dentaire, trouble de la déglutition, dépression, médicament, douleur, textures inadaptées, absence d'aide, volonté de la personne.

5. La commission des usagers (CDU).

6. 36 / 150 × 100 = 24 %.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.10.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau sur la fin de vie et celui des instances.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.9 et je refais les exercices d'application.

6.3.10 La responsabilité du professionnel dans une action collective

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Essentiels M1 S6 §2.3 (p. 23 et 24)

Figure 6.6 – Les trois formes de responsabilité

Comprendre le schéma – Figure 6.6

1. La **responsabilité civile** oblige à **réparer** un dommage causé à autrui (article 1240 du Code civil pour la faute ; 1241 pour la négligence ou l'imprudence) : il faut une faute, un dommage et un lien de causalité. Elle est couverte par l'**assurance** de responsabilité civile professionnelle (du professionnel libéral, de l'employeur pour les salariés, de l'établissement de formation et de l'organisme d'accueil pour le stagiaire, selon la convention de stage).

2. La **responsabilité pénale** sanctionne une **infraction** : blessures involontaires (une brûlure grave par négligence), mise en danger de la vie d'autrui, violation du secret professionnel (226-13), non-assistance à personne en danger.

3. La **responsabilité disciplinaire** relève de l'employeur (règlement intérieur, fiche de poste) et, pour les

professions dotées d'un ordre, de l'instance ordinale (ce n'est pas le cas des diététiciens).

4. En atelier culinaire, les risques principaux sont les **brûlures et coupures**, les **réactions allergiques** et les **toxi-infections alimentaires** : la prévention (chapitre 13 du volume 2, fiche F8) protège les participants et le professionnel.

Risque en atelier	Prévention et traçabilité
Allergie	Recueil écrit des allergies à l'inscription, affichage des 14 allergènes de chaque recette, vérification des étiquettes, variantes, protocole d'urgence et numéros d'appel (15 ou 112) affichés
Toxi-infection alimentaire collective (TIAC)	Hygiène des mains et des surfaces, chaîne du froid, cuisson à cœur, consommation rapide ou refroidissement des restes ; une TIAC (au moins deux cas groupés présentant des symptômes similaires, dont la cause peut être rapportée à une même origine alimentaire) est une maladie à déclaration obligatoire auprès de l'ARS
Brûlures, coupures	Consignes de sécurité, matériel adapté, encadrement suffisant (1 animateur pour 4 à 6 participants, davantage avec des enfants), trousse de secours
Chute, malaise	Locaux adaptés, personne formée aux premiers secours, procédure d'appel
Enfants	Autorisation parentale, présence d'un parent ou encadrement adapté, tâches adaptées à l'âge

Attention – Le statut du stagiaire

Le stagiaire agit **sous la responsabilité** de son tuteur et de la structure d'accueil, dans le cadre d'une **convention de stage** tripartite (établissement de formation, organisme d'accueil, étudiant) qui précise les assurances. Il ne réalise pas seul une activité à risque (four, enfants) sans encadrement, et il rend compte à son tuteur de tout incident.

Obligation de moyens, obligation de sécurité et assurance

Le professionnel de santé est en général tenu à une **obligation de moyens** : il doit mettre en œuvre tous les moyens conformes aux connaissances actuelles pour atteindre l'objectif, sans pouvoir garantir le résultat. Un diététicien ne peut pas promettre qu'une personne perdra du poids ou que son diabète sera équilibré ; il doit en revanche donner des conseils exacts, adaptés et prudents.

Dans certains domaines, l'obligation est plus forte. Lorsqu'on **fournit des aliments** à des personnes (buffet, dégustation, repas d'un atelier), on doit garantir qu'ils ne présentent pas de danger : c'est une obligation de **sécurité**. Une toxi-infection due à une rupture de la chaîne du froid engage donc facilement la responsabilité de l'organisateur.

Notion	Signification	Exemple
Obligation de moyens	Faire tout ce qui est raisonnablement possible, sans garantir le résultat	Conseils adaptés lors d'un atelier ; orientation vers le médecin en cas de signe d'alerte
Obligation de sécurité	Ne pas exposer les personnes à un danger	Aliments servis sains, matériel en bon état, encadrement suffisant
Faute	Manquement à une règle ou à la prudence attendue	Ne pas vérifier les allergies déclarées ; laisser des enfants seuls près d'une plaque chaude

Notion	Signification	Exemple
Aléa	Dommage qui survient sans faute	Une personne fait un malaise sans lien avec l'atelier, malgré un déroulement normal

Définition – Assurance de responsabilité civile professionnelle

Contrat qui prend en charge les conséquences financières des dommages causés à autrui dans l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est **obligatoire** pour les professionnels de santé qui exercent à titre libéral (article L. 1142-2 du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002). Le salarié est couvert par l'assurance de son employeur pour les actes réalisés dans le cadre de sa mission. Le stagiaire est couvert selon les clauses de sa convention de stage.

Méthode pas à pas – Préparer un atelier en réduisant les risques

1. Inscription : recueillir par écrit les allergies, les régimes, les contacts d'urgence, les autorisations parentales.

2. Recette : vérifier les 14 allergènes réglementaires, prévoir des variantes, lire les étiquettes le jour même.

3. Locaux et matériel : vérifier les plaques, les fours, les couteaux, la trousse de secours, les numéros d'urgence affichés.

4. Encadrement : calculer le nombre d'adultes nécessaires selon le public et les tâches.

5. Hygiène : lavage des mains, chaîne du froid, cuisson à cœur, glacière pour le transport.

6. Après l'atelier : noter tout incident, même léger, et en informer le responsable.

Exemple – Calcul : l'encadrement d'un atelier parents-enfants

Un atelier accueille 9 parents et 14 enfants de 6 à 10 ans. La structure prévoit un animateur pour 4 enfants lors des tâches de découpe et de cuisson, les parents restant responsables de leur propre enfant, et un animateur pour 6 adultes.

- Pour les enfants : 14 / 4 = 3,5, arrondi à l'entier supérieur : **4** adultes encadrants pendant la découpe et la cuisson.
- Pour les parents : 9 / 6 = 1,5, soit **2** animateurs.

Si les parents participent activement à côté de leur enfant, l'équipe peut s'organiser à 4 animateurs au total ; sinon, il faut prévoir des postes de cuisson réservés aux adultes. On arrondit toujours le nombre d'encadrants **à l'entier supérieur**.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.22

Pour un atelier de 18 enfants de 8 ans avec un ratio d'un adulte pour 5 enfants pendant la cuisson, calculez le nombre d'adultes nécessaires. Indiquez ensuite si chaque situation relève d'une faute ou d'un aléa : a) un enfant allergique au lait, signalé à l'inscription, goûte une sauce à la crème ; b) un enfant tombe en courant dans la cour pendant la pause, sous la surveillance d'un adulte.

Corrigé

18 / 5 = 3,6, soit **4** adultes. a) Faute : l'allergie était connue et aurait dû être prise en compte dans la recette et la surveillance. b) Plutôt un aléa si la surveillance était normale et les lieux sans danger particulier ; une faute pourrait être retenue si la surveillance était insuffisante ou si un danger connu (sol glissant) n'avait pas été signalé.

Allergies et projets d'accueil individualisés : une responsabilité partagée

L'allergie alimentaire est le risque grave le plus fréquent dans les ateliers et en restauration collective. Elle engage à la fois la **sécurité** des personnes et la **confidentialité** des informations de santé.

Outil	Contenu	Qui y a accès ?
Projet d'accueil individualisé (PAI)	Document rédigé à la demande de la famille, avec le médecin, pour un enfant atteint d'une maladie chronique ou d'une allergie ; il précise les aménagements (panier-repas, éviction) et le protocole d'urgence	Les personnes qui encadrent l'enfant, selon ce qui est prévu dans le PAI
Fiche d'inscription à un atelier	Allergies, régimes, contacts d'urgence	L'animateur et le responsable de l'atelier
Information sur les allergènes des plats (règlement (UE) n° 1169/2011, décret du 17 avril 2015 pour les denrées non préemballées)	Présence des 14 allergènes réglementaires dans chaque plat	Tous les convives, par affichage ou sur demande

La liste des 14 allergènes réglementaires comprend : céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites (au-delà de 10 mg par kg ou par litre), lupin, mollusques.

Attention – Sécurité et confidentialité : trouver l'équilibre

Afficher dans le réfectoire une liste nominative des enfants allergiques permet à tout le personnel de les repérer, mais expose des données de santé à la vue de tous (élèves, parents, prestataires). La bonne pratique est un document accessible aux seuls agents qui servent les repas, avec photo si besoin, rangé dans un lieu non visible du public, et mis à jour à chaque rentrée. La sécurité est assurée sans diffusion inutile.

Exemple – Calcul : préparer une dégustation en sécurité

Un atelier « goûters » prévoit trois recettes pour 20 participants. Les fiches d'inscription signalent 2 allergies à l'arachide, 1 allergie à l'œuf et 1 intolérance au lactose.

- Recette 1, cookies au beurre de cacahuète : contient arachide, gluten, lait, œuf. Elle exclut au moins 3 participants (2 arachide, 1 œuf) et ne convient pas à la personne intolérante au lactose sans adaptation.
- Recette 2, compote pomme-poire : aucun des 14 allergènes. Elle convient à tous.
- Recette 3, gâteau au yaourt : gluten, lait, œuf ; une variante au yaourt sans lactose est possible, mais l'œuf exclut 1 participant.

Décision : remplacer la recette 1, car le risque de contamination par l'arachide est élevé pour tout le groupe (traces sur les mains, les ustensiles), et la remplacer par des crêpes à la farine, à la boisson végétale et à la banane, sans œuf.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.23

Un centre de loisirs vous demande s'il peut coller sur la porte du réfectoire la liste « Enfants allergiques : Lina (arachide), Tom (œuf), Sami (lait) ». Expliquez le problème et proposez une organisation conforme.

Corrigé

La liste affiche des données de santé nominatives à la vue de tous (autres enfants, parents, livreurs), sans nécessité : c'est contraire au secret et au principe de minimisation du RGPD, et elle peut stigmatiser les enfants. Organisation conforme : un classeur ou une fiche rangés à l'office, accessibles aux seuls animateurs

et agents de service, avec le PAI et le protocole d'urgence de chaque enfant ; un repère discret au moment du service (plateau de couleur, place habituelle choisie avec la famille) ; une mise à jour à chaque période et une information des nouveaux animateurs.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.10 – La responsabilité

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la différence entre une obligation de moyens et une obligation de sécurité ?
2. Pour qui l'assurance de responsabilité civile professionnelle est-elle obligatoire ?
3. Pour 23 enfants et un ratio d'un adulte pour 5 enfants, combien d'adultes faut-il ?
4. Citez huit des 14 allergènes réglementaires.
5. Qu'est-ce qu'un projet d'accueil individualisé ?
6. Pourquoi ne faut-il pas afficher la liste nominative des enfants allergiques à la porte du réfectoire ?

Corrigé – Point d'étape 6.3.10

1. L'obligation de moyens impose de tout faire pour atteindre l'objectif sans garantir le résultat ; l'obligation de sécurité impose de ne pas exposer les personnes à un danger, par exemple avec des aliments sains.
2. Pour les professionnels de santé qui exercent à titre libéral.
3. 23 / 5 = 4,6, soit 5 adultes.
4. Gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques.
5. Un document établi à la demande de la famille avec le médecin pour un enfant atteint d'une maladie chronique ou d'une allergie, qui précise les aménagements et le protocole d'urgence.
6. Cela expose des données de santé à tous sans nécessité et peut stigmatiser les enfants.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.11.
3 ou 4 sur 6	Je relis la méthode de préparation d'un atelier et la partie sur les allergies.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.10 et je refais les exercices d'application.

6.3.11 Publicité, allégations et compléments alimentaires : repères pour une information loyale

Module · Référentiel : C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 6.2.2)

Les allégations nutritionnelles et de santé

Le **règlement (CE) n° 1924/2006** encadre les **allégations** figurant sur les denrées et dans la publicité : seules les allégations figurant sur des listes autorisées, avec des conditions précises, sont permises.

Allégation (exemples)	Condition (règlement 1924/2006, annexe)
« Source de fibres »	Au moins 3 g de fibres pour 100 g ou 1,5 g pour 100 kcal
« Riche en fibres »	Au moins 6 g pour 100 g ou 3 g pour 100 kcal
« Source de protéines »	Au moins 12 % de l'énergie apportée par les protéines
« Riche en protéines »	Au moins 20 % de l'énergie apportée par les protéines

Allégation (exemples)	Condition (règlement 1924/2006, annexe)
« Sans sucres ajoutés »	Aucun mono- ou disaccharide ni aucune denrée utilisée pour ses propriétés édulcorantes ajouté ; mention « contient des sucres naturellement présents » si c'est le cas
« Allégé », « réduit en… »	Réduction d'au moins 30 % par rapport à un produit similaire (25 % pour le sel)
« Faible teneur en sel »	Au plus 0,12 g de sodium pour 100 g (soit environ 0,3 g de sel)

Les **allégations de santé** (« le calcium est nécessaire au maintien d'une ossature normale ») doivent être autorisées par la Commission européenne après avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et figurer dans le registre de l'Union.

Exemple – Calcul détaillé : une allégation est-elle justifiée ?

Un biscuit annonce « riche en fibres ». Étiquette pour 100 g : énergie 460 kcal ; fibres 5,2 g ; protéines 7,5 g.

- Critère par masse : 5,2 g < 6 g pour 100 g : **non rempli**.
- Critère par énergie : fibres pour 100 kcal = 5,2 / 460 × 100 = **1,13 g** < 3 g : **non rempli**.
- « Source de fibres » serait possible : 5,2 g ≥ 3 g pour 100 g : condition remplie.
- « Source de protéines » ? Énergie apportée par les protéines : 7,5 × 4 = 30 kcal ; 30 / 460 × 100 = **6,5 %** < 12 % : non.

Conclusion : l'allégation « riche en fibres » n'est pas conforme ; le diététicien peut utiliser cet exemple en atelier de littératie critique (chapitre 5) et, s'il le constate dans le cadre professionnel, le signaler à la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), qui contrôle l'étiquetage.

La publicité alimentaire et les messages sanitaires

Depuis la loi relative à la politique de santé publique de 2004 et son décret d'application de 2007, les publicités pour des aliments manufacturés ou des boissons avec ajout de sucres, de sel ou d'édulcorants doivent comporter un **message sanitaire** (« Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour », « … évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé », « … pratiquez une activité physique régulière », « … évitez de grignoter entre les repas ») et l'adresse *mangerbouger.fr*, ou verser une contribution à Santé publique France. L'efficacité limitée de ces bandeaux et l'exposition des enfants à la publicité alimentaire (déterminants commerciaux, chapitre 2) alimentent un débat sur un encadrement plus strict, recommandé par le HCSP et l'OMS ; vérifier l'état de la réglementation dans le cadre du PNNS 5.

Les compléments alimentaires

Les **compléments alimentaires** (directive 2002/46/CE ; décret n° 2006-352 en France) sont des denrées destinées à compléter l'alimentation normale, présentées sous forme de doses (gélules, comprimés). Ils ne sont pas des médicaments et ne peuvent revendiquer de propriétés de prévention ou de guérison des maladies. Ils sont déclarés auprès de la DGCCRF ; l'ANSES pilote un dispositif de **nutrivigilance** qui recueille les effets indésirables. En santé publique, le diététicien rappelle qu'une alimentation variée couvre en général les besoins, signale les situations où une supplémentation est recommandée (vitamine B12 chez le végétalien, vitamine D selon avis médical, acide folique avant la conception) et reste **indépendant** de toute marque (6.3.7).

Le Nutri-Score : une information loyale au service de l'autonomie

Le **Nutri-Score** est un logo nutritionnel à cinq couleurs et cinq lettres (de A, vert foncé, à E, orange foncé) placé sur la face avant des emballages. Il a été recommandé en France par un arrêté du 31 octobre 2017 et il reste **facultatif** pour les fabricants, car le droit européen ne permet pas à un pays de l'imposer seul. Son algorithme a été révisé en 2022 pour les aliments et en 2023 pour les boissons, puis rendu applicable en France par l'arrêté du 14 mars 2025, afin de mieux distinguer certains produits (céréales complètes, produits sucrés, boissons édulcorées) ; les nouveaux logos remplacent progressivement les anciens sur les emballages.

Sur le plan éthique, le Nutri-Score est un exemple de mesure du **bas de l'échelle d'intervention** (informer) : il n'interdit rien, il aide le consommateur à comparer rapidement des produits d'une même catégorie. Il respecte donc l'**autonomie** tout en favorisant la **justice**, car il est plus facile à comprendre qu'un tableau nutritionnel pour les personnes qui ont une littératie limitée (chapitre 5).

Atout	Limite
Lecture rapide, sans calcul	Facultatif : certaines marques ne l'affichent pas
Permet de comparer des produits d'un même rayon	Ne compare pas des produits très différents (une huile et un soda)
Pousse certains fabricants à améliorer leurs recettes	Ne tient pas compte du degré de transformation, des additifs ou des pesticides
Utile en atelier de littératie	Un produit classé A peut être consommé en excès ; un produit classé D peut avoir sa place dans une alimentation variée

Attention – Un outil de comparaison, pas un jugement moral

En atelier, on évite de parler de « bons » produits A et de « mauvais » produits E, ce qui moraliserait l'alimentation. On présente le Nutri-Score comme un outil pour **comparer** deux produits que l'on hésite à acheter : « Entre ces deux céréales, laquelle est la plus intéressante au quotidien ? » Un fromage classé D reste une source de calcium et de plaisir.

Exemple – Comparer deux produits d'un même rayon

Deux boîtes de céréales du petit déjeuner (produits fictifs) coûtent le même prix : céréales chocolatées classées D (sucres 28 g pour 100 g, fibres 4 g) et flocons d'avoine classés A (sucres 1 g, fibres 9 g). Pour une portion de 40 g, les céréales chocolatées apportent 28 × 40 / 100 = **11,2 g** de sucres, soit près de trois morceaux de sucre de 4 g (11,2 / 4 = 2,8) ; les flocons d'avoine en apportent 1 × 40 / 100 = **0,4 g**. On peut proposer de mélanger les deux pour garder le plaisir du chocolat en réduisant les sucres.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.24

Une enseigne propose d'afficher dans son rayon « Mangez A, évitez E ! » avec une photo d'enfant souriant devant les produits A. Analysez ce message au regard de l'information loyale et de la non-stigmatisation, et proposez un autre message.

Corrigé

Le message transforme un outil de comparaison en règle morale (« évitez E »), il est inexact (un produit E peut être consommé occasionnellement, et le Nutri-Score ne compare que des produits d'une même catégorie), et il peut culpabiliser les familles qui achètent des produits E pour des raisons de goût ou de prix. L'enseigne peut aussi l'utiliser pour mettre en avant ses propres produits. Autre message : « Le Nutri-Score vous aide à comparer des produits du même rayon. Pour vos achats de tous les jours, regardez les lettres A et B. »

Lire le marketing des emballages avec un œil critique

Au-delà des allégations réglementées, les emballages utilisent de nombreux procédés pour donner une image favorable du produit. Certains mots ne sont encadrés par aucune définition légale précise, d'autres le sont strictement. Savoir les distinguer fait partie de la **littératie critique** (chapitre 5) et de l'information loyale.

Mention ou procédé	Statut	Ce qu'il faut savoir
« Naturel », « authentique », « recette de grand-mère »	Pas de définition générale ; interdit seulement s'il est trompeur	Ne garantit ni l'absence d'additifs ni l'intérêt nutritionnel

Mention ou procédé	Statut	Ce qu'il faut savoir
« Fait maison » en restauration	Encadré par un décret de 2015 : plat cuisiné sur place à partir de produits crus, avec quelques exceptions	Ne concerne que la restauration, pas les produits emballés
« Bio » (eurofeuille, logo AB)	Encadré par le règlement européen sur l'agriculture biologique	Garantit un mode de production, pas une meilleure composition nutritionnelle
« Sans conservateurs », « sans colorants »	Autorisé si c'est exact et si la loi n'interdit pas déjà ces additifs dans ce produit	Peut donner une image « santé » à un produit très sucré
Images de fruits, de champs, de sportifs	Interdites seulement si elles trompent sur la composition	Un yaourt « aux fruits » peut contenir très peu de fruits : vérifier le pourcentage dans la liste des ingrédients
Personnages de dessins animés, jeux, cadeaux	Pas interdits sur les emballages en France	Procédés de marketing destinés aux enfants, souvent sur des produits gras, sucrés ou salés

Définition – Pratique commerciale trompeuse

Pratique qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur, notamment sur les qualités substantielles, la composition ou les propriétés d'un produit (articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation). Elle est sanctionnée pénalement et contrôlée par la DGCCRF.

Exemple – Calcul : la part réelle de fruit

Une boisson « aux fruits rouges » (produit fictif) indique dans sa liste d'ingrédients : « eau, sucre, jus de fruits rouges à base de concentré 6 %, arômes ». Pour une bouteille de 1,5 L, le jus de fruits représente 1 500 × 0,06 = **90 mL**, soit moins d'un demi-verre (un verre contient environ 200 mL). L'image de fruits débordant de l'étiquette ne correspond pas à cette réalité, ce que l'on peut faire découvrir en atelier en versant 90 mL d'eau colorée dans un verre.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.25

Un biscuit pour enfants porte les mentions « Recette authentique », « Sans colorants », « Source de céréales » et un personnage de dessin animé. Il contient 32 g de sucres pour 100 g. Classez chaque mention (réglementée ou non) et rédigez la question que vous poseriez aux parents en atelier pour développer leur esprit critique.

Corrigé

« Recette authentique » : non réglementée, elle ne dit rien de la composition. « Sans colorants » : autorisée si elle est exacte, mais elle détourne l'attention des 32 g de sucres. « Source de céréales » : formule ambiguë, qui imite une allégation nutritionnelle sans correspondre à une allégation autorisée ; elle peut être trompeuse. Personnage de dessin animé : procédé de marketing destiné aux enfants. Question : « Si vous retournez le paquet, qu'est-ce qui vous surprend dans le tableau nutritionnel par rapport à ce que dit le devant de l'emballage ? »

Compléments alimentaires : des risques réels et un rôle de conseil

Les compléments alimentaires sont souvent perçus comme « naturels » et donc sans danger. Pourtant, le dispositif de **nutrivigilance** de l'Anses reçoit chaque année des déclarations d'effets indésirables, parfois graves : atteintes du foie, troubles cardiaques, interactions avec des médicaments, surdosages.

Situation à risque	Exemple	Conseil du diététicien
Surdosage	Plusieurs produits contenant la même vitamine pris en même temps ; produits enrichis en vitamine D donnés à des nourrissons à des doses trop élevées, qui ont conduit l'Anses à alerter en 2021 sur des cas d'hypercalcémie	Faire la liste de tous les produits pris ; préférer les médicaments prescrits par le médecin quand une supplémentation est nécessaire
Interaction avec un médicament	Millepertuis qui diminue l'efficacité de certains médicaments (contraceptifs, anticoagulants)	Toujours signaler au médecin et au pharmacien les compléments pris
Population sensible	Femmes enceintes, enfants, personnes âgées polymédiquées, sportifs	Pas de complément sans avis médical
Achat sur internet hors de l'Union européenne	Produits « minceur » contenant des substances interdites	Déconseiller l'achat de produits dont l'origine et la composition ne sont pas vérifiables
Promesses non autorisées	« Détox », « brûle-graisses », « renforce l'immunité » sans allégation autorisée	Expliquer que ces promesses ne sont pas prouvées

Méthode pas à pas – Conseiller une personne qui prend des compléments

1. Recenser sans juger : quels produits, depuis quand, à quelle dose, pourquoi, sur quel conseil ?

2. Comprendre l'attente : fatigue, minceur, performance, prévention ? Quelle est la vraie préoccupation ?

3. Informer de façon loyale : ce qui est prouvé, ce qui ne l'est pas, les risques possibles.

4. Proposer des alternatives alimentaires quand elles existent (aliments riches en fer, en vitamine C, en fibres).

5. Orienter vers le médecin ou le pharmacien en cas de symptômes, de traitement en cours ou de population sensible.

6. Signaler un effet indésirable suspecté (nutrivigilance), en lien avec un professionnel de santé.

Exemple – Calcul : comparer un complément et des aliments

Une personne achète un complément « vitamine C 500 mg » à 9,90 € les 30 comprimés, soit 9,90 / 30 = **0,33 €** par jour. La référence nutritionnelle pour la population fixée par l'Anses est de 110 mg par jour pour un adulte. Une orange de 150 g de chair apporte 150 × 47,5 / 100 = **71,3 mg** de vitamine C (orange crue, 47,5 mg pour 100 g, code 13034 de la table Ciqual 2025), et 100 g de poivron rouge cru en apportent 121 mg (code 20087). Une alimentation qui contient des fruits et des légumes chaque jour couvre donc le besoin, sans dépense supplémentaire et avec d'autres bénéfices (fibres, potassium, plaisir). La dose de 500 mg dépasse largement le besoin : l'excédent est éliminé dans les urines.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.26

Une étudiante sportive prend chaque jour une poudre protéinée, un complément « énergie » contenant de la caféine et un complément de fer acheté sans avis médical. Elle dit se sentir nerveuse. Indiquez trois questions à lui poser, deux risques possibles et votre conduite.

Corrigé

Questions : quelles doses prenez-vous et depuis quand ? Buvez-vous aussi du café, du thé ou des boissons énergisantes ? Pourquoi avez-vous commencé le fer, une prise de sang a-t-elle été faite ? Risques : excès de caféine (nervosité, palpitations, troubles du sommeil) ; surcharge en fer sans carence prouvée (troubles digestifs, toxicité à long terme) ; dépenses inutiles. Conduite : lui conseiller d'arrêter le complément « énergie », de parler du fer à son médecin avant de continuer, de vérifier si ses apports en protéines par l'alimentation suffisent, et de signaler ses symptômes à un médecin ; en cas d'effet indésirable avéré, une déclaration de nutrivigilance peut être faite.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.11 – Allégations, marketing et compléments

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Le Nutri-Score est-il obligatoire en France ? Pourquoi ?
2. À quel échelon de l'échelle d'intervention correspond-il ?
3. La mention « naturel » est-elle définie par la loi ?
4. Une boisson de 1 L contient 8 % de jus de fruits. Quel volume de jus contient-elle ?
5. Citez deux risques liés aux compléments alimentaires.
6. Une boîte de 60 comprimés coûte 12 €. Quel est le coût par jour pour un comprimé par jour ?

Corrigé – Point d'étape 6.3.11

1. Non, il est facultatif, car le droit européen ne permet pas à un pays de l'imposer seul.
2. Au bas de l'échelle : informer.
3. Non, elle n'a pas de définition générale ; elle est interdite seulement si elle est trompeuse.
4. 1 000 × 0,08 = 80 mL.
5. Surdosage, interaction avec un médicament, substances interdites dans des produits achetés en ligne, dépenses inutiles.
6. 12 / 60 = 0,20 € par jour.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.12.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux sur le Nutri-Score et sur le marketing.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.11 et je refais les exercices d'application.

6.3.12 Enquêtes, recherche et protection des personnes

Module · Référentiel : C3.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 6.2.2)

Les projets de santé publique comportent souvent des **enquêtes** (diagnostic, évaluation). Leur cadre juridique dépend de leur **finalité**.

Situation	Cadre	Démarches
Questionnaire anonyme de diagnostic ou d'évaluation d'une action, sans finalité de recherche	RGPD (si données personnelles) ; pas de recherche au sens de la loi Jardé	Mention d'information, minimisation, anonymat, registre de la structure

Situation	Cadre	Démarches
Recherche impliquant la personne humaine (RIPH), visant à développer les connaissances biologiques ou médicales (catégories 1, 2, 3 de la loi Jardé, 2012)	Code de la santé publique ; avis d'un comité de protection des personnes (CPP)	Protocole, information, consentement (ou non-opposition pour la catégorie 3), conformité CNIL (méthodologies de référence MR-001 à MR-003)
Recherche n'impliquant pas la personne humaine, étude ou évaluation à partir de données existantes (dossiers, bases)	RGPD ; méthodologie de référence MR-004 de la CNIL ou autorisation	Information des personnes, inscription au répertoire public des études
Mémoire universitaire ou travail d'étudiant	Selon la nature : souvent hors loi Jardé si pas de finalité de connaissance généralisable ; avis éventuel d'un comité d'éthique local	Se renseigner auprès de l'établissement de formation

Méthode pas à pas – Les principes éthiques d'une enquête de terrain

1. **Finalité** claire et utile au public.
2. **Information** loyale (qui, pourquoi, comment, quels usages).
3. **Liberté** de participer ou non, et d'arrêter, sans conséquence.
4. **Anonymat** ou pseudonymisation ; **minimisation** des données ; pas de données sensibles inutiles.
5. **Respect** des personnes (questions non intrusives, langue adaptée, durée raisonnable).
6. **Restitution** des résultats aux participants.
7. **Sécurité** des données et suppression à la date prévue.

Les trois catégories de recherches impliquant la personne humaine

La loi Jardé distingue trois catégories de recherches impliquant la personne humaine (RIPH), selon le niveau de risque et de contrainte pour les participants. Toutes nécessitent un **protocole** et l'**avis favorable d'un comité de protection des personnes** (CPP), désigné par tirage au sort au niveau national.

Catégorie	Définition	Exemple en nutrition	Accord des participants
1 – Interventionnelle	Intervention non justifiée par la prise en charge habituelle, avec des risques possibles	Essai d'un nouveau complément nutritionnel oral chez des patients dénutris	Consentement libre, éclairé et écrit ; autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament si un produit de santé est testé
2 – Interventionnelle à risques et contraintes minimes	Intervention qui ne comporte que des risques et contraintes minimes (liste fixée par arrêté)	Mesure de la composition corporelle par impédancemétrie, questionnaires répétés, prise de sang supplémentaire de faible volume	Consentement libre, éclairé et exprès (écrit ou oral tracé)
3 – Non interventionnelle (observationnelle)	Actes et produits utilisés de façon habituelle, sans procédure inhabituelle de diagnostic ou de surveillance	Observation des consommations au repas d'un service hospitalier pour étudier le lien avec la durée de séjour	Information et absence d'opposition

Un **comité de protection des personnes** est composé de membres bénévoles issus du domaine de la recherche et de la santé et de membres de la société civile (représentants d'associations d'usagers, juristes, spécialistes de l'éthique). Il vérifie notamment la pertinence de la recherche, la qualité de l'information et les modalités de

recueil du consentement, l'adéquation entre les objectifs et les moyens, et la protection des personnes vulnérables.

Définition – Note d'information d'une recherche

Document remis aux participants avant leur accord. Il précise l'objectif et la méthode de la recherche, sa durée, les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, les alternatives, les modalités de prise en charge en cas de problème, l'avis du CPP, la possibilité de refuser ou d'arrêter à tout moment sans conséquence, et les droits sur les données (RGPD). Pour une recherche de catégorie 1, le consentement est ensuite recueilli par écrit.

Exemple – Calcul : le taux de participation à une recherche

Une équipe propose une recherche de catégorie 2 à 160 patients d'un service de gériatrie (exemple fictif). 112 acceptent, 31 refusent et 17 ne peuvent pas donner leur accord en raison de troubles cognitifs sévères.

- Taux d'acceptation parmi les patients sollicités : 112 / 160 × 100 = **70,0 %**.
- Parmi les patients en mesure de décider : 112 / (160 − 17) = 112 / 143 × 100 = **78,3 %**.

Pour les 17 patients qui ne peuvent pas consentir, la loi prévoit des règles spécifiques (consentement du représentant légal ou d'un proche, intérêt direct ou bénéfice collectif, risque minime). Les résultats doivent aussi signaler que les patients les plus atteints sont peut-être sous-représentés.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.27

Classez chaque projet dans une catégorie de la loi Jardé, ou hors recherche impliquant la personne humaine : a) tester l'effet d'un régime enrichi en fibres sur la glycémie de patients diabétiques, avec des prises de sang répétées ; b) observer, sans rien changer, les quantités consommées au déjeuner par des résidents d'EHPAD pour étudier leur lien avec la perte de poids ; c) évaluer la satisfaction des participants d'un atelier cuisine.

Corrigé

a) Recherche interventionnelle : catégorie 1 si le régime ou les prélèvements présentent des risques, catégorie 2 s'ils restent dans la liste des risques et contraintes minimes ; dans tous les cas avis du CPP et consentement. b) Catégorie 3, recherche non interventionnelle, si l'objectif est de produire des connaissances ; information des résidents et absence d'opposition, avis du CPP. c) Hors recherche : évaluation d'une action, soumise au RGPD si des données personnelles sont recueillies.

L'intégrité scientifique : un devoir aussi pour l'étudiant

L'**intégrité scientifique** désigne l'ensemble des règles qui garantissent l'honnêteté et la rigueur d'un travail de recherche ou d'étude. En France, la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche l'a inscrite dans le Code de la recherche. Les trois manquements les plus graves sont regroupés sous le sigle **FFP**.

Manquement	Définition	Exemple dans un dossier d'étudiant
Fabrication	Inventer des données ou des résultats	Écrire que 40 questionnaires ont été recueillis alors que seuls 15 l'ont été
Falsification	Modifier des données, des méthodes ou des résultats pour obtenir la conclusion souhaitée	Supprimer les réponses négatives pour améliorer le taux de satisfaction
Plagiat	Présenter comme sien le travail d'autrui sans le citer	Copier un paragraphe d'un site internet ou un texte produit par une IA sans le signaler

D'autres pratiques sont aussi contraires à l'intégrité : ne pas citer ses sources, présenter des données fictives comme réelles, choisir uniquement les études qui vont dans son sens, ne pas déclarer un lien d'intérêts.

Méthode pas à pas – Citer correctement ses sources dans un dossier

1. Toute information qui n'est pas de vous (chiffre, définition, recommandation) est suivie d'une référence.

2. Une citation mot pour mot est mise entre guillemets, avec la référence.

3. La référence comporte l'auteur ou l'organisme, le titre, l'année et, pour un site, l'adresse et la date de consultation : « Santé publique France. Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes. 2019. Consulté le 10 octobre 2026. »

4. Les données fictives (exercices, cas simulés) sont toujours signalées comme fictives.

5. L'aide d'un outil d'IA, quand elle est autorisée, est signalée (quel outil, pour quelle tâche) et chaque information produite est vérifiée dans une source fiable.

Attention – Fraude aux examens

Présenter à l'épreuve E5 des données inventées, des photos d'une action à laquelle on n'a pas participé ou un texte rédigé par une autre personne ou par une IA comme son propre travail constitue une **fraude**. Elle peut entraîner l'annulation de l'épreuve et une interdiction de se présenter à un examen pendant plusieurs années. Au-delà de la sanction, elle trahit la confiance du jury et des personnes qui ont participé à l'action.

Exemple – Présenter honnêtement un résultat décevant

Une étudiante voulait recueillir 60 questionnaires ; elle en a obtenu 22. Elle n'a pas complété les réponses. Dans son dossier, elle écrit : « 22 questionnaires ont été recueillis sur les 60 prévus (36,7 %). Ce faible effectif ne permet pas de généraliser les résultats. La passation à la sortie de l'école, en fin de journée, explique sans doute en partie cette faible participation ; une passation pendant la fête de quartier aurait permis de toucher davantage de familles. » Cette analyse des limites est valorisée par le jury, car elle montre une démarche honnête et réflexive.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.28

Pour chaque pratique, indiquez s'il s'agit de fabrication, de falsification, de plagiat ou d'une pratique correcte : a) arrondir 66,67 % à 66,7 % ; b) retirer d'un tableau trois réponses « pas du tout satisfait » parce qu'elles « faussent la moyenne » ; c) reprendre un schéma de Santé publique France en citant la source ; d) ajouter dix questionnaires remplis soi-même pour atteindre l'effectif prévu.

Corrigé

a) Pratique correcte : arrondi annoncé et habituel. b) Falsification : des données réelles sont supprimées pour modifier le résultat. c) Pratique correcte, à condition de citer la source et de respecter les conditions de réutilisation. d) Fabrication : des données sont inventées.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.12 – Enquêtes et recherche

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les trois catégories de recherches impliquant la personne humaine.

2. Comment est désigné le comité de protection des personnes qui examine un projet ?

3. Quel accord est demandé aux participants d'une recherche de catégorie 3 ?

4. Que signifie le sigle FFP ?

5. Sur 90 personnes sollicitées, 63 acceptent. Calculez le taux d'acceptation.

6. Que doit-on indiquer quand on utilise des données fictives dans un dossier ?

Corrigé – Point d'étape 6.3.12

1. Interventionnelle ; interventionnelle à risques et contraintes minimes ; non interventionnelle.

2. Par tirage au sort au niveau national.

3. Une information et l'absence d'opposition.

4. Fabrication, falsification, plagiat.

5. 63 / 90 × 100 = 70 %.

6. Qu'elles sont fictives.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.13.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau des catégories Jardé et celui de l'intégrité scientifique.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.12 et je refais les exercices d'application.

6.3.13 Identité numérique et e-réputation du professionnel

Module · Référentiel : C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 6.2.2)

Le référentiel (compétence C3.5) demande de **maîtriser son identité numérique** et de prendre en compte les enjeux de l'**e-réputation**. L'identité numérique est l'ensemble des traces associées à une personne sur internet (profils, publications, commentaires, photos) ; l'e-réputation est l'image qui s'en dégage.

Bonne pratique	Pourquoi
Séparer comptes personnels et professionnels	Éviter que des contenus privés soient associés à la fonction
Paramétrer la confidentialité des comptes personnels	Les partenaires, patients et futurs employeurs consultent les profils
Ne jamais publier de données ou de photos de participants sans autorisation spécifique	Droit à l'image, RGPD, secret (6.3.4 à 6.3.6)
Publier des contenus sourcés et datés	Information loyale ; crédibilité
Ne pas répondre à chaud aux critiques ; signaler les contenus diffamatoires	Préserver la relation et la réputation de la structure
Mentionner tout partenariat commercial	Loi du 9 juin 2023 sur l'influence commerciale
Vérifier régulièrement ce qui apparaît à son nom (moteur de recherche)	Maîtriser son image professionnelle

Répondre à la désinformation nutritionnelle

Les fausses informations sur l'alimentation circulent vite sur les réseaux sociaux : régimes miracles, aliments « poisons », jeûnes extrêmes, « détox ». Le diététicien a un rôle de **prévention** face à ces contenus, mais sa réponse doit rester respectueuse, sourcée et efficace. Contredire brutalement une personne risque de renforcer sa conviction.

Méthode pas à pas – Répondre à une fausse information en quatre temps

1. Écouter et reconnaître la préoccupation : « Vous avez raison de vous intéresser à ce que contiennent les aliments. »

2. Commencer par le fait exact, pas par le mythe : répéter le mythe risque de le renforcer. « Les produits

laitiers apportent du calcium et des protéines, et ils ont leur place dans une alimentation variée. »

3. Expliquer simplement pourquoi l'information circulait : « Ce message vient souvent de vidéos qui vendent des produits ou des programmes. »

4. Donner une source fiable et datée, et proposer d'en reparler : « Les recommandations de Santé publique France sont sur mangerbouger.fr. »

Indice d'une information douteuse	Exemple
Promesse rapide et spectaculaire	« Perdez 10 kg en 2 semaines »
Un seul aliment présenté comme miracle ou comme poison	« Le citron brûle les graisses », « le gluten est toxique pour tous »
Absence de source, ou source vague	« Des scientifiques ont prouvé… »
Vente d'un produit ou d'un programme	Code promo, lien d'achat
Témoignages à la place de données	« Ça a marché pour moi »
Discours contre « les autorités » ou « les médecins »	« Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez »

Attention – Rester dans son rôle

Le diététicien ne se moque pas des personnes qui ont cru une fausse information : cela arrive à tout le monde, et la honte empêche de changer d'avis. Il ne s'en prend pas non plus personnellement à l'auteur d'un contenu (risque de diffamation, de conflit public). Il corrige l'information, pas la personne.

Le télésoin et les consultations à distance

Depuis la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, le **télésoin** permet à des auxiliaires médicaux et à des pharmaciens de suivre des patients à distance, par vidéotransmission, dans des conditions fixées par décret (2021). Ces pratiques facilitent l'accès aux soins dans les territoires peu dotés, mais elles posent des questions éthiques.

Enjeu	Bonne pratique
Consentement	Proposer le télésoin sans l'imposer, recueillir l'accord de la personne
Confidentialité	Outil sécurisé ; professionnel seul dans une pièce fermée ; vérifier que le patient peut parler librement
Fracture numérique	Proposer une alternative en présentiel ou par téléphone ; aider à l'installation
Qualité	Première consultation en présentiel quand c'est possible ; limites (pas de pesée ni d'observation complète)
Traçabilité	Compte rendu dans le dossier, comme pour une consultation sur place

À vous de jouer – Exercice d'application 6.29

Un participant vous dit en atelier : « J'ai vu qu'il faut arrêter complètement le sucre, même les fruits, parce que le sucre nourrit le cancer. » Rédigez votre réponse en appliquant les quatre temps de la méthode.

Corrigé

1. « Je comprends que ce sujet vous inquiète, beaucoup de gens se posent la question. » 2. « Les fruits font partie des aliments qui protègent la santé : ils apportent des fibres, des vitamines et des antioxydants, et les recommandations conseillent d'en manger chaque jour. Ce qui est conseillé, c'est de limiter les produits sucrés et les boissons sucrées. » 3. « L'idée que le sucre nourrit le cancer vient d'une simplification : toutes les cellules utilisent du glucose, et supprimer les fruits ne soigne pas un cancer ;

> cela peut au contraire faire maigrir et affaiblir une personne malade. » 4. « Vous pouvez trouver des informations fiables sur le site de l'Institut national du cancer et sur mangerbouger.fr. Si vous êtes concerné, parlez-en à votre médecin, et nous pouvons en reparler ensemble. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.13 – Le numérique

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi faut-il commencer par le fait exact plutôt que par le mythe ?
2. Citez quatre indices d'une information douteuse.
3. Pourquoi ne faut-il pas se moquer d'une personne qui a cru une fausse information ?
4. Quelle loi a créé le télésoin ?
5. Citez deux bonnes pratiques de confidentialité lors d'une consultation à distance.
6. Quelle alternative faut-il prévoir pour les personnes éloignées du numérique ?

Corrigé – Point d'étape 6.3.13

1. Répéter le mythe en premier risque de le renforcer dans la mémoire.
2. Promesse rapide, aliment miracle ou poison, absence de source, vente d'un produit, témoignages, discours contre les autorités.
3. La honte empêche de changer d'avis et rompt la relation.
4. La loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.
5. Outil sécurisé ; professionnel seul dans une pièce fermée ; vérifier que le patient peut parler librement.
6. Une consultation en présentiel ou par téléphone, et une aide à l'installation.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.14.
3 ou 4 sur 6	Je relis la méthode en quatre temps et le tableau sur le télésoin.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.13 et je refais les exercices d'application.

6.3.14 Cinq dilemmes éthiques commentés

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 6.2.2)

Les situations suivantes, fréquentes en stage et en début d'exercice, sont analysées avec la grille en 5 étapes (6.3.8). Elles n'ont pas une seule « bonne réponse » : l'important est le **raisonnement** et sa **justification**.

Situation	Règles et valeurs en tension	Options envisagées	Décision argumentée
1. Un participant arrive à l'atelier en état d'ivresse	Sécurité (four, couteaux) et respect de la personne ; non-malfaisance pour lui et le groupe	Le laisser participer ; l'exclure devant le groupe ; lui parler en privé	Lui parler en privé, avec respect ; lui proposer de revenir la semaine suivante ; prévenir la référente ; ne pas le laisser manipuler le matériel dangereux ; proposer une orientation si la situation se répète
2. Une mère demande de ne pas mettre son enfant à côté d'un enfant « d'une autre origine »	Non-discrimination (loi, déontologie) et respect de la parole de la mère	Accepter ; refuser sèchement ; expliquer le cadre	Rappeler calmement que l'atelier est ouvert à tous sans distinction ; ne pas modifier l'organisation sur ce motif ; en informer la référente

Situation	Règles et valeurs en tension	Options envisagées	Décision argumentée
3. Un financeur demande la liste nominative des participants	Secret, RGPD (minimisation) et obligation de rendre compte	Envoyer la liste ; refuser sans explication ; proposer des données agrégées	Transmettre des données agrégées (nombre, profils anonymes) et les émargements seulement si la convention l'exige et si les personnes en ont été informées
4. Une collègue publie un « avant/après » de la silhouette d'une participante qui a perdu du poids (avec son accord)	Autonomie (accord de la personne) et non-malfaisance (message centré sur le poids, effet sur les autres)	Laisser ; demander le retrait ; proposer un autre message	En parler à la collègue, expliquer le risque de stigmatisation et de restriction ; proposer un témoignage centré sur le plaisir de cuisiner, avec l'accord de la participante
5. La structure veut réserver les ateliers aux familles « qui le méritent » (assiduité dans d'autres activités)	Justice (accès selon les besoins) et contraintes de places	Accepter le critère ; tirage au sort ; critères de besoin	Proposer des critères transparents liés aux besoins (orientation par les partenaires, priorité aux familles les plus éloignées), une liste d'attente et un cycle supplémentaire

Attention – Tracer ses décisions

Dans chaque cas, le professionnel **informe** sa hiérarchie ou son tuteur, **note** la situation et la décision dans un journal de bord (sans données inutiles) et **revient** sur la situation en analyse de pratique : c'est ainsi que se construit une posture éthique.

Cinq autres dilemmes pour s'entraîner

Les cinq situations suivantes complètent le tableau précédent. Essayez d'abord de les analyser seul avec la grille en cinq étapes, puis lisez la proposition de réponse. Comme pour les dilemmes commentés, plusieurs réponses peuvent être défendues : c'est la qualité de la justification qui compte.

Situation	Règles et valeurs en tension	Options envisagées	Décision argumentée
6. Un adolescent de 16 ans vous confie en atelier qu'il se fait vomir après les repas et vous demande de ne rien dire à ses parents	Secret et confiance de l'adolescent ; protection d'un mineur ; non-malfaisance (trouble du comportement alimentaire possible)	Garder le secret ; prévenir les parents sans lui en parler ; l'accompagner vers un professionnel	L'écouter sans juger, lui expliquer que sa santé est en jeu et que vous ne pouvez pas garder cela pour vous seul ; en parler à votre tuteur et à l'infirmière ou au médecin de la structure ; chercher avec lui la façon d'informer ses parents et de consulter (médecin, maison des adolescents)
7. Un élu demande de présenter dans le bilan du projet « les familles les plus en difficulté » avec photos et prénoms, pour obtenir une subvention	Rendre compte au financeur ; secret, droit à l'image, dignité	Accepter ; refuser sans proposer d'alternative ; proposer un bilan anonymisé avec témoignages autorisés	Bilan chiffré et agrégé, témoignages anonymes recueillis avec accord, photos de plats et de mains ; expliquer à l'élu que la dignité des familles est aussi un gage de confiance pour la suite

Situation	Règles et valeurs en tension	Options envisagées	Décision argumentée
8. Une participante très en retard à chaque séance perturbe le groupe ; l'animatrice veut l'exclure	Justice (accès) ; respect du groupe ; bienveillance	Exclure ; ne rien dire ; en parler en privé et adapter	Entretien individuel pour comprendre (horaires de travail, garde d'enfants, transports) ; adapter l'accueil (arrivée échelonnée, tâches qui peuvent commencer plus tard) ; rappeler le cadre au groupe sans la désigner
9. Un médecin vous demande de faire signer aux patients un formulaire autorisant l'utilisation de leurs données pour une étude, « sans trop expliquer, sinon ils refusent »	Autonomie, information loyale, cadre de la recherche ; relation avec le médecin	Obéir ; refuser sèchement ; discuter et proposer une information claire	Refuser de recueillir un consentement non éclairé ; en parler au médecin et proposer une note d'information claire ; vérifier que l'étude a reçu les autorisations nécessaires ; informer son responsable si le désaccord persiste
10. Votre employeur, une collectivité, vous demande de relayer sur vos comptes personnels une campagne municipale à la veille d'une élection	Neutralité du service public ; liberté d'expression ; séparation vie privée et vie professionnelle	Relayer ; refuser ; relayer uniquement les messages de santé sur le compte de la structure	Ne pas utiliser ses comptes personnels pour une communication de l'employeur, encore moins en période électorale ; diffuser les messages de santé publique sur les supports officiels, dans le respect des règles de communication en période électorale

Astuce – Repérer le principe dominant

Dans beaucoup de dilemmes, un principe l'emporte quand un **danger grave** existe pour une personne vulnérable (situation 6) : la protection passe alors avant le secret, mais toujours en informant la personne de ce que l'on va faire et pourquoi. Quand il n'y a pas de danger grave, l'**autonomie** et la **dignité** des personnes priment souvent (situations 7 et 8).

À vous de jouer – Exercice d'application 6.30

Une diététicienne de PMI (protection maternelle et infantile) constate qu'une mère donne à son nourrisson de 4 mois une boisson végétale à base d'amande à la place du lait infantile, par conviction. Rédigez l'analyse en cinq étapes et la phrase par laquelle vous ouvririez la discussion avec la mère.

Corrigé

Faits : nourrisson de 4 mois, alimenté par une boisson végétale non adaptée à ses besoins, choix lié aux convictions de la mère. **Règles** : les boissons végétales ne sont pas des substituts du lait maternel ou des préparations pour nourrissons et ne couvrent pas ses besoins (protéines, énergie, calcium, fer, vitamines) ; la protection de l'enfance s'impose en cas de danger. **Valeurs** : respect des convictions et de l'autonomie parentale contre bienfaisance et non-malfaisance envers l'enfant, qui ne peut pas se protéger. **Options** : respecter le choix sans rien dire (rejetée, danger) ; signaler immédiatement sans dialogue (rejetée en première intention si la mère est prête à changer) ; informer, chercher une solution compatible avec ses convictions (allaitement si possible, préparation infantile à base de protéines végétales adaptée, sur conseil du médecin) et organiser un suivi médical rapproché. **Décision** : troisième option, en lien immédiat avec le médecin de PMI ; si l'enfant présente des signes de dénutrition ou si la mère refuse toute adaptation, l'équipe envisage une information préoccupante. Phrase d'ouverture : « Je vois que vous faites très attention à ce que

vous donnez à votre bébé. Est-ce que vous voulez bien qu'on regarde ensemble ce dont il a besoin à son âge, et les laits qui peuvent correspondre à vos choix ? »

6.3.15 Laïcité et neutralité dans les actions de santé publique

Module · Référentiel et guide : voir 6.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 6.2.2)

La **laïcité** (loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l'État ; article 1er de la Constitution de 1958) garantit la liberté de conscience et l'égalité de tous, quelles que soient leurs convictions. Elle n'impose pas la même obligation à tous les acteurs.

Acteur	Obligation
Agents publics (fonctionnaires, contractuels)	Stricte neutralité religieuse et politique dans l'exercice de leurs fonctions (Code général de la fonction publique)
Salariés d'organismes privés chargés d'une mission de service public	Soumis à la neutralité depuis la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, pour les activités de service public
Salariés d'associations ou d'entreprises privées	Liberté de manifester ses convictions, sauf restrictions justifiées et proportionnées prévues par le règlement intérieur
Usagers (participants, élèves, résidents)	Libres de leurs convictions et de leurs pratiques, dans le respect de l'ordre public et du bon fonctionnement du service (règles spécifiques pour les élèves des écoles, collèges et lycées publics : loi du 15 mars 2004)
Stagiaire	Se conforme aux règles de la structure d'accueil ; en structure publique, adopte la même réserve que les agents

Exemple – Situations fréquentes en atelier ou en restauration

- **Menus de substitution** à la cantine : il n'existe pas d'obligation légale de proposer un plat de substitution au porc ; le Conseil d'État a toutefois rappelé (2020) que la collectivité qui modifie ses pratiques doit prendre en compte l'intérêt des enfants ; de nombreuses collectivités proposent une alternative ou une option végétarienne quotidienne, qui répond au plus grand nombre.
- **Jeûne** : on adapte l'organisation (horaires, repas à emporter) sans exiger ni décourager la pratique, et on veille à la sécurité (hydratation, pathologies, avis médical).
- **Demande de prière ou de pause** pendant un atelier : dans une structure associative, la réponse dépend du règlement intérieur et du bon déroulement de l'activité ; on cherche une solution simple et respectueuse (pause prévue dans le déroulé).
- **Professionnel** : le diététicien n'exprime pas ses propres convictions religieuses ou politiques dans l'exercice de ses fonctions en structure publique ; il respecte et sécurise les pratiques alimentaires des personnes (chapitre 4), sans les juger ni les promouvoir.

Attention – Laïcité et accueil de tous

La laïcité n'est pas un argument pour **exclure** des pratiques alimentaires : elle garantit à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire. Dans une action de santé publique, l'objectif reste l'**accessibilité** de l'action au plus grand nombre (recettes compatibles avec la majorité des pratiques, sans référence religieuse).

Les menus végétariens en restauration collective : liberté de choix et santé publique

La question des menus végétariens illustre bien l'articulation entre **liberté de choix**, **santé publique** et **environnement** dans la restauration collective.

Texte	Contenu	Champ
Loi EGalim du 30 octobre 2018	Expérimentation, à partir de novembre 2019, d'un menu végétarien au moins une fois par semaine	Restauration scolaire
Loi Climat et résilience du 22 août 2021	Pérennisation du menu végétarien hebdomadaire ; expérimentation d'une option végétarienne quotidienne pour les collectivités volontaires	Restauration scolaire
Même loi	Option végétarienne quotidienne lorsque plusieurs menus sont proposés, à partir du 1er janvier 2023	Restaurants collectifs gérés par l'État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales

Ces mesures ne relèvent pas de la **laïcité** : elles ne visent pas des convictions religieuses, mais la diversification des sources de protéines et la réduction de l'impact environnemental. Elles respectent aussi les choix des personnes qui ne mangent pas de viande, quelle qu'en soit la raison.

Sur le plan éthique, un menu végétarien doit rester **équilibré** : il apporte des protéines (légumineuses associées à des céréales, œufs, produits laitiers), du fer et de la vitamine B12 par les produits animaux non carnés quand ils sont présents. Un menu « végétarien » réduit à des pâtes à la sauce tomate ne répond ni à l'objectif de santé ni au respect des convives.

Exemple – Calcul : la part de menus végétariens sur un cycle

Une cantine propose un cycle de 20 déjeuners sur quatre semaines, avec 4 menus végétariens (un par semaine), et une option végétarienne en plus sur 6 autres jours. Part des repas où un plat végétarien est disponible : (4 + 6) / 20 × 100 = **50 %**. Part des repas entièrement végétariens pour tous : 4 / 20 × 100 = **20 %**. Pour les 92 élèves qui ne mangent pas de viande sur 380 inscrits (24,2 %), l'offre végétarienne quotidienne n'est pas encore atteinte : la commune peut s'engager dans l'expérimentation prévue par la loi.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.14 et 6.3.15 – Dilemmes, laïcité, menus

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quand la protection d'une personne peut-elle passer avant le secret ?
2. Pourquoi faut-il informer la personne de ce que l'on va faire, même quand on rompt la confidentialité pour la protéger ?
3. Les agents publics et les usagers du service public ont-ils les mêmes obligations de neutralité ?
4. Existe-t-il une obligation légale de proposer un plat de substitution au porc à la cantine ?
5. Depuis quelle loi le menu végétarien hebdomadaire est-il pérennisé en restauration scolaire ?
6. Sur 20 déjeuners, 5 sont végétariens. Calculez le pourcentage.

Corrigé – Point d'étape 6.3.14 et 6.3.15

1. Quand il existe un danger grave pour une personne vulnérable (mineur, personne qui ne peut pas se protéger).
2. Pour préserver la confiance, respecter sa dignité et l'associer autant que possible à la suite.
3. Non : les agents publics sont tenus à la neutralité ; les usagers sont libres de leurs convictions, dans le respect de l'ordre public et du bon fonctionnement du service.
4. Non, mais la collectivité doit prendre en compte l'intérêt des enfants si elle modifie ses pratiques.

5. La loi Climat et résilience du 22 août 2021.
6. 5 / 20 × 100 = 25 %.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe au fil rouge et au cas guidé.
3 ou 4 sur 6	Je relis les dilemmes et le tableau sur la laïcité.
Moins de 3 sur 6	Je relis les parties 6.3.14 et 6.3.15 et je refais les exercices d'application.

6.3.16 Fil rouge : les choix éthiques d'Inès

Module · Référentiel et guide : voir 6.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 6.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès a mis en place

- **Confidentialité** : cadre énoncé à chaque atelier (« ce qui se dit ici reste ici ») ; aucune information individuelle transmise à l'école ou au CCAS, seulement des données agrégées.
- **RGPD** : questionnaire de diagnostic anonyme (ni nom ni adresse, âge en tranches), mention d'information en tête ; questionnaires saisis puis détruits ; fichier protégé par mot de passe sur l'ordinateur du centre social ; suppression prévue le 15 septembre 2028.
- **Droit à l'image** : 12 autorisations distribuées, 9 signées pour les adultes ; pour les enfants, 7 autorisations signées par les deux parents sur 15 enfants présents : 7 / 15 × 100 = **46,7 %**. Inès a donc photographié surtout les mains et les plats et flouté les autres visages.
- **Conflit d'intérêts** : une enseigne de biscuits a proposé d'offrir les goûters ; Inès et sa tutrice ont refusé, car le thème de l'atelier était justement les goûters faits maison ; la supérette du quartier a fourni les fruits contre une simple mention « avec le soutien de » au bas de l'affiche, après accord de la direction.
- **Non-stigmatisation** : aucune pesée, aucune image de corps, vocabulaire « plaisir, petit budget, famille ».

Fil rouge – centre social des tilleuls – Compléments : sécurité, allégations et droits aux Tilleuls

- **Sécurité des ateliers** : fiche d'inscription avec allergies et contacts d'urgence (12 fiches, 2 allergies signalées : arachide et kiwi) ; affichage des allergènes de chaque recette ; trousse de secours ; numéros d'urgence affichés ; une brûlure légère (atelier 3) consignée dans le cahier de liaison et signalée à la tutrice, sans suite.
- **Convention de stage** : assurance responsabilité civile de l'établissement de formation et du centre social ; Inès n'utilise jamais le four avec les enfants sans la présence de l'animatrice.
- **Allégations** : en préparant l'atelier « étiquettes », Inès a repéré un biscuit « riche en fibres » à 4,8 g pour 100 g : allégation non conforme (seuil de 6 g) ; elle en a fait un exercice de littératie critique et l'a signalé à sa tutrice.
- **Droits et dignité** : le projet a été présenté au conseil d'administration du centre social, auquel participent des habitants ; les familles orientées par l'épicerie solidaire choisissaient librement de participer, et leur participation n'était pas une condition d'accès à l'épicerie.
- **Numérique** : aucune photo d'Inès avec les familles n'a été publiée sur ses comptes personnels ; les publications du centre social respectaient les autorisations par support.

6.3.17 Cas guidé : repérer la dénutrition des seniors à domicile

Module · Référentiel et guide : voir 6.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 6.2.2)

Ce cas guidé reprend l'ensemble des notions du chapitre sur un même projet. Lisez la situation, essayez de répondre à chaque question, puis comparez avec la réponse commentée.

Mise en situation – Le projet du CCAS de Val-Fleuri (données fictives)

Le centre communal d'action sociale (CCAS) de Val-Fleuri livre chaque jour des repas à 140 personnes âgées de 75 ans et plus. Les livreurs constatent que certains plateaux reviennent presque pleins. Le CCAS veut lancer un projet de repérage de la dénutrition : les livreurs noteraient chaque jour les restes sur une tablette, une diététicienne pèserait les bénéficiaires à domicile tous les trois mois, et les résultats seraient transmis aux médecins traitants et aux familles. Un fabricant de compléments nutritionnels oraux propose de fournir gratuitement les tablettes, en échange de la liste des personnes « à risque » pour leur envoyer des échantillons.

Question 1 – Quels sont les bénéfices attendus et les risques éthiques du projet ?

Bénéfices (bienfaisance) : la dénutrition est fréquente chez les personnes âgées vivant à domicile, souvent méconnue, et elle augmente le risque de chutes, d'infections et d'hospitalisation ; un repérage précoce permet d'agir (enrichissement, aide aux repas, orientation médicale). Risques : atteinte à la vie privée (surveillance quotidienne des restes), sentiment d'être contrôlé, données de santé recueillies par des personnes non soignantes, transmission aux familles sans accord, utilisation commerciale des données par le fabricant.

Question 2 – Quelles règles s'appliquent aux données recueillies ?

Le relevé des restes et le poids sont des données de santé (catégorie particulière du RGPD). Le CCAS, responsable du traitement, doit définir une finalité précise (repérer un risque de dénutrition pour proposer un accompagnement), une base légale (mission d'intérêt public, avec l'exception de l'article 9 relative à la prise en charge sociale ou sanitaire), informer chaque bénéficiaire, ne recueillir que le nécessaire (un relevé simple « tout, la moitié, presque rien » plutôt qu'un détail par plat), limiter l'accès aux personnes habilitées, sécuriser la tablette et fixer une durée de conservation. Plusieurs critères de la CNIL sont réunis (données de santé, personnes vulnérables, suivi systématique) : une analyse d'impact est nécessaire. Le délégué à la protection des données de la commune est consulté.

Question 3 – Le secret permet-il de transmettre les résultats aux médecins et aux familles ?

Le médecin traitant ne fait pas partie de la même équipe que le CCAS : la transmission suppose l'**accord** de la personne. Les familles ne sont pas des professionnels : rien ne leur est transmis sans l'accord de la personne âgée, qui reste un adulte capable de décider, sauf mesure de protection juridique et dans les limites de celle-ci. La personne de confiance peut être associée si la personne le souhaite.

Question 4 – Comment recueillir le consentement des bénéficiaires ?

Lors d'une visite, la diététicienne présente le projet à l'oral et avec un document simple en gros caractères : le but, ce qui est noté, qui le verra, la possibilité de refuser sans que la livraison des repas change. Elle vérifie la compréhension (« pouvez-vous me redire ce que nous allons noter ? ») et recueille un accord écrit pour la pesée et pour la transmission au médecin. Pour les personnes présentant des troubles cognitifs, on recherche leur assentiment et l'on associe la personne de confiance ou le représentant légal selon la situation.

Question 5 – Que répondre au fabricant de compléments ?

La proposition est à **refuser** : la transmission d'une liste de personnes « à risque » à une entreprise serait une violation du secret et du RGPD (utilisation commerciale de données de santé, sans consentement et pour une finalité étrangère au projet), et l'envoi d'échantillons à des personnes vulnérables relève de la promotion. Le CCAS peut chercher d'autres financements pour les tablettes (conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, caisse de retraite, budget communal) et, si des compléments sont nécessaires, ils sont prescrits par le médecin.

Question 6 – Comment rendre le projet plus respectueux et plus juste ?

Remplacer le relevé quotidien systématique par un relevé simple une semaine par mois, ou seulement chez les personnes qui l'ont accepté ; proposer la pesée lors de la visite annuelle plutôt que tous les trois mois, et seulement si elle est utile ; former les livreurs à repérer et à signaler avec tact, sans commentaire devant la personne ; associer des bénéficiaires et le conseil d'administration du CCAS à la conception ; prévoir des

réponses concrètes (portage adapté, aide aux courses, repas partagés au foyer-restaurant) pour que le repérage débouche sur une aide.

Exemple – Calcul : estimer la charge du repérage

Avec 140 bénéficiaires et une pesée tous les trois mois, il faut 140 × 4 = **560** visites par an. À raison de 30 minutes par visite, déplacement compris, cela représente 560 × 0,5 = **280 heures** de diététicienne par an. Avec une pesée annuelle seulement pour les personnes qui l'acceptent (par exemple 70 % d'entre elles, soit 98 personnes), on passe à 98 × 0,5 = **49 heures**, ce qui libère du temps pour accompagner les personnes repérées. La proportionnalité est aussi une question de bon usage des ressources.

6.4 Approfondissements

6.4.1 Le diététicien sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont un canal de prévention puissant, mais ils exposent à des risques déontologiques : conseils individualisés donnés publiquement sans bilan, promotion de produits (placement de produits, codes promotionnels), images de « transformations » corporelles, publication de photos d'ateliers sans autorisation, réponses à des personnes présentant des signes de TCA. La loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale impose notamment d'indiquer clairement la **nature publicitaire** d'un contenu et interdit certaines promotions. Le diététicien reste tenu par son code de déontologie : **information loyale**, **indépendance**, **secret**, **orientation**.

Méthode pas à pas – Cinq règles pour une publication professionnelle

1. Ne publier que des contenus **sourcés** et à jour (repères officiels).
2. Ne jamais publier de photo de participants sans **autorisation écrite** spécifique aux réseaux sociaux.
3. Signaler tout partenariat ou avantage reçu (« collaboration commerciale »).
4. Ne pas donner de conseil individualisé en commentaire : orienter vers une consultation.
5. Éviter les avant/après corporels et le vocabulaire de la minceur.

Créer un compte de prévention : la charte éditoriale

Une structure (centre social, service de santé, association) qui ouvre un compte sur un réseau social pour diffuser des messages de prévention a intérêt à écrire une **charte éditoriale**. Ce document court fixe les règles de publication et de modération, et il protège à la fois le public et les professionnels.

Rubrique de la charte	Contenu (exemple)
Objectif du compte	Informer les habitants sur les ateliers et diffuser des repères de nutrition fiables
Public visé	Familles du quartier, adolescents, seniors
Sources autorisées	Santé publique France, Anses, Haut Conseil de la santé publique, sociétés savantes ; chaque contenu est daté
Ce que l'on ne publie pas	Photos de participants sans autorisation spécifique aux réseaux sociaux ; images de corps, avant/après ; marques et produits ; conseils individualisés
Validation	Chaque publication est relue par une deuxième personne de l'équipe avant diffusion
Modération	Réponse sous 48 heures ouvrées aux questions générales ; orientation en message privé vers une consultation pour les questions personnelles ; suppression des propos injurieux, discriminants ou publicitaires

Rubrique de la charte	Contenu (exemple)
Partenariats	Aucun partenariat commercial ; les soutiens institutionnels sont mentionnés sobrement
Données	Aucune collecte de données des abonnés en dehors des statistiques globales de la plateforme

Méthode pas à pas – Vérifier une publication avant de la diffuser

1. Exactitude : l'information est-elle conforme à une source officielle récente ?

2. Clarté : une personne qui lit peu comprend-elle le message en dix secondes ?

3. Respect : le message ou l'image peut-il blesser, stigmatiser ou culpabiliser quelqu'un ?

4. Image et données : toutes les personnes reconnaissables ont-elles autorisé cette diffusion sur ce réseau ?

5. Indépendance : une marque apparaît-elle sur la photo (emballage, logo) ?

6. Source : la référence et la date sont-elles indiquées ?

Exemple – Calcul : suivre l'impact d'un compte

Le compte d'un centre social (exemple fictif) a publié 24 messages en trois mois. Les publications « recette petit budget » ont obtenu en moyenne 180 vues et 12 partages ; les publications « repères nutritionnels » 95 vues et 3 partages. Taux de partage : 12 / 180 × 100 = **6,7 %** pour les recettes, 3 / 95 × 100 = **3,2 %** pour les repères. Les recettes concrètes intéressent davantage : l'équipe décide d'intégrer les repères dans les recettes (« cette soupe compte pour deux portions de légumes »). Ces chiffres mesurent l'audience, pas le changement de comportement : ils ne suffisent pas à évaluer l'action.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.31

Un animateur veut publier sur le compte du centre social une photo prise pendant l'atelier : on y voit trois participantes souriantes, une boîte de céréales de marque au premier plan, avec le texte « Nos mamans apprennent enfin à bien nourrir leurs enfants ! ». Appliquez la méthode de vérification et proposez une version corrigée.

Corrigé

Exactitude : le message ne contient aucune information de nutrition. Respect : « enfin » et « apprennent à bien nourrir » sont condescendants et culpabilisants ; « nos mamans » réduit les participantes à leur rôle de mère. Image : il faut vérifier que les trois participantes ont autorisé la diffusion sur ce réseau. Indépendance : la marque de céréales doit être retirée du cadre. Source : sans objet ici. Version corrigée : une photo des mains et des plats, sans emballage de marque, avec le texte « Atelier du mardi : crêpes et compote maison pour le goûter, moins de 50 centimes la part ! Prochain atelier le 14 mars, ouvert à tous. »

6.4.2 Les partenariats public-privé en nutrition

Les partenariats avec l'industrie agroalimentaire ou la grande distribution peuvent apporter des moyens (locaux, produits, financements), mais soulèvent des questions de **crédibilité** et d'**indépendance** : l'industrie peut utiliser l'action comme outil de communication (« marketing de la bonne cause »). Les recommandations internationales (OMS) invitent à une **analyse de risque** avant tout partenariat : objectifs compatibles avec la santé, absence de promotion de produits, contrôle des contenus par la partie publique, transparence des financements, possibilité de rompre. Le PNNS distingue ainsi ses messages institutionnels des communications commerciales (la mention « Pour votre santé… » des publicités alimentaires en est l'illustration).

Une grille chiffrée pour décider d'un partenariat

Pour éviter de décider « au feeling », une structure peut analyser chaque proposition de partenariat avec une grille de critères notés. La grille ne remplace pas la réflexion, mais elle rend la décision **transparente** et **comparable** d'une proposition à l'autre.

Critère	0 point	1 point	2 points
Cohérence des produits ou activités du partenaire avec les messages de santé	Contradictoire	Neutre	Cohérent
Visibilité demandée	Logo, produit mis en avant	Mention discrète	Aucune
Maîtrise des contenus	Le partenaire intervient sur les messages	Relecture demandée	Liberté totale de la structure
Accès aux participants ou à leurs données	Demandé	Indirect (enquête)	Aucun
Convention écrite	Refusée	Partielle	Complète
Durée et dépendance financière	Plus de 30 % du budget	10 à 30 %	Moins de 10 %
Transparence	Le partenaire refuse d'être mentionné	Mention partielle	Mention publique claire

Règle de décision proposée : 12 à 14 points, partenariat acceptable ; 8 à 11 points, à négocier ; moins de 8 points ou un seul 0 sur les critères « cohérence » ou « données », refus.

Exemple – Appliquer la grille à deux propositions

Proposition A : une mutuelle finance 600 € d'ingrédients pour un budget de 5 000 €, demande une mention dans le bilan, n'intervient pas sur les contenus et signe une convention. Cohérence 2, visibilité 1, contenus 2, données 2, convention 2, dépendance : 600 / 5 000 × 100 = 12,0 %, soit 1 point, transparence 2. Total : **12 points**, partenariat acceptable.

Proposition B : une enseigne de restauration rapide offre 1 500 € en échange de son logo sur les affiches et d'un stand de dégustation. Cohérence 0, visibilité 0, contenus 1, données 2, convention 1, dépendance : 1 500 / 5 000 × 100 = 30,0 %, soit 1 point, transparence 2. Total : **7 points**, avec un 0 en cohérence : refus.

Attention – Les limites de la grille

Une grille peut donner une impression d'objectivité trompeuse. Les seuils sont des choix de l'équipe et doivent être discutés. Certains critères comptent plus que d'autres (une collecte de données à des fins commerciales justifie à elle seule un refus). Enfin, la grille doit être appliquée **avant** de connaître le montant, pour ne pas être tenté de l'ajuster au profit d'une proposition généreuse.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.32

Une coopérative de producteurs de fruits propose de fournir gratuitement des fruits de saison (valeur 400 € pour un budget de 3 200 €) pour des ateliers en école, avec son nom sur le bilan, sans intervention sur les contenus, avec une convention complète. Elle demande seulement à distribuer un dépliant de recettes à son nom. Calculez la part du budget, notez la proposition avec la grille et concluez.

Corrigé

Part : 400 / 3 200 × 100 = 12,5 %, soit 1 point. Cohérence 2 ; visibilité : le dépliant à son nom est une mise en avant, 0 ou 1 selon sa présentation (1 si les recettes sont neutres et sans promotion de marque) ; contenus 2 ; données 2 ; convention 2 ; transparence 2. Total : 11 ou 12 points. Conclusion : partenariat acceptable ou à négocier ; on peut demander de remplacer le dépliant par une simple mention, ou relire le dépliant pour

vérifier qu'il ne contient que des recettes conformes aux repères, sans message publicitaire.

6.4.3 La participation des personnes : une exigence éthique

Associer les personnes concernées à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation d'une action (habitants, usagers, patients partenaires) est à la fois un principe de promotion de la santé (Charte d'Ottawa, chapitre 1), une condition d'efficacité et une exigence de **respect** : on ne fait pas « pour » les gens sans eux. Elle suppose de reconnaître leurs savoirs d'expérience, de rémunérer ou défrayer leur contribution quand c'est possible et de leur restituer les résultats.

L'échelle de la participation d'Arnstein

En 1969, la sociologue américaine Sherry Arnstein a proposé une **échelle de la participation citoyenne** en huit barreaux, regroupés en trois niveaux. Elle reste un outil simple pour évaluer si un projet associe réellement les personnes ou s'il se contente de les informer.

Niveau	Barreaux (du bas vers le haut)	Ce que cela donne dans un projet de nutrition
Non-participation	1. Manipulation ; 2. Thérapie (au sens d'« éduquer » les personnes pour qu'elles acceptent)	On fait signer une liste de présence pour prouver la « participation » ; on organise une réunion pour convaincre les habitants d'un projet déjà décidé
Participation symbolique	3. Information ; 4. Consultation ; 5. Conciliation (quelques représentants associés, sans pouvoir réel)	Affiche annonçant les ateliers ; questionnaire sur les attentes ; un habitant invité au comité de pilotage
Pouvoir effectif des citoyens	6. Partenariat ; 7. Délégation de pouvoir ; 8. Contrôle citoyen	Les habitants choisissent les recettes et les horaires avec l'équipe ; un groupe d'habitants gère un budget pour les ateliers ; une association d'habitants porte elle-même le projet

La plupart des projets se situent aux barreaux 3 et 4 (information et consultation). Ce n'est pas une faute, mais l'échelle invite à se demander si l'on peut **monter d'un barreau** : passer d'un questionnaire de satisfaction à un groupe d'habitants qui co-construit le prochain cycle, par exemple.

Lien diététique – Participation et efficacité

La participation n'est pas seulement un principe éthique. Les actions construites avec les personnes concernées sont en général mieux adaptées à leurs habitudes, à leur budget et à leur culture, et elles mobilisent davantage. C'est un argument que le diététicien peut utiliser face à un financeur qui juge la concertation trop longue.

Exemple – Situer un projet sur l'échelle

Un projet « petits déjeuners » dans un collège (exemple fictif) : l'infirmière a choisi les produits, une affiche a informé les élèves, et un questionnaire de satisfaction a été distribué à la fin. Position : barreaux 3 (information) et 4 (consultation). Pour monter d'un barreau, on peut constituer un groupe d'élèves volontaires, avec des délégués, qui choisit une partie des produits dans un budget donné, organise le service et présente les résultats au conseil d'administration : on atteint le partenariat (barreau 6).

À vous de jouer – Exercice d'application 6.33

Situez chaque pratique sur l'échelle d'Arnstein : a) une commune présente aux parents les nouveaux menus

de la cantine, déjà votés ; b) un comité de résidents d'un foyer décide du budget des repas festifs ; c) une association invite un habitant au comité de pilotage, mais les décisions sont prises avant la réunion ; d) un questionnaire demande aux familles leurs préférences pour les ateliers.

Corrigé

a) Information (barreau 3), voire thérapie si l'objectif est seulement de faire accepter une décision. b) Délégation de pouvoir (barreau 7). c) Conciliation (barreau 5), participation symbolique : la présence ne donne aucun pouvoir réel. d) Consultation (barreau 4).

6.4.4 Éthique et intelligence artificielle en santé

L'usage d'outils d'intelligence artificielle (IA) pour rédiger des supports, analyser des données ou répondre au public soulève des questions éthiques : **confidentialité** (ne jamais saisir de données personnelles ou de santé dans un outil non sécurisé), **exactitude** (erreurs présentées avec assurance), **biais** (les données d'apprentissage peuvent reproduire des stéréotypes), **transparence** (indiquer quand un contenu a été produit avec l'aide d'une IA), **responsabilité** (le professionnel reste responsable de ce qu'il diffuse). Le règlement européen sur l'intelligence artificielle (*AI Act*, 2024) classe les usages selon leur niveau de risque et impose des obligations progressives. Dans le cadre d'une formation et d'un examen, présenter comme sien un travail produit par une IA ou par une autre personne relève en outre de la **fraude**, contraire à l'intégrité académique.

Le règlement européen sur l'IA et l'usage professionnel des outils

Le règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle, entré en vigueur le 1er août 2024, classe les systèmes d'IA selon leur **niveau de risque** et fixe des obligations proportionnées. Ses dispositions s'appliquent par étapes : interdictions depuis le 2 février 2025, règles pour les modèles d'IA à usage général depuis le 2 août 2025, obligations de transparence depuis le 2 août 2026 ; le règlement (UE) 2026/1744 du 24 juillet 2026 a reporté les obligations des systèmes à haut risque au 2 décembre 2027 (et au 2 août 2028 pour ceux intégrés à des produits).

Niveau de risque	Exemples	Règle
Inacceptable	Notation sociale des personnes, manipulation qui exploite la vulnérabilité liée à l'âge ou au handicap	Interdit
Élevé	Certains dispositifs médicaux intégrant de l'IA, systèmes qui décident de l'accès à des prestations sociales	Obligations strictes : gestion des risques, qualité des données, documentation, contrôle humain
Transparence	Agents conversationnels, contenus générés ou modifiés par IA (images, vidéos truquées)	Informer les personnes qu'elles échangent avec une IA ou qu'un contenu a été généré
Minimal	Filtres anti-spam, correcteurs d'orthographe	Pas d'obligation particulière

Pour le diététicien, les outils d'IA générative (rédaction, traduction, résumé) sont utiles pour gagner du temps, mais ils peuvent produire des **erreurs présentées avec assurance**, inventer des références, reproduire des **biais** (stéréotypes culturels sur l'alimentation, modèles alimentaires occidentaux pris comme norme) et poser des problèmes de **confidentialité**.

Méthode pas à pas – Utiliser une IA générative pour un support d'atelier

1. Vérifier les règles : la structure ou l'établissement de formation autorise-t-il l'outil, et pour quel usage ?

2. Ne saisir aucune donnée personnelle : pas de nom, pas d'information de santé, pas de situation identifiable.

3. Formuler une demande précise : public, niveau de langue, longueur, sources à respecter.

4. Vérifier chaque information dans une source officielle datée (repères, seuils, chiffres) et corriger.

5. Relire le ton : pas de culpabilisation, pas de stéréotype, exemples adaptés au public réel.

6. Tester avec le public : faire relire par une ou deux personnes concernées (« faire dire », chapitre 5).

7. Être transparent : indiquer, quand c'est pertinent, qu'un outil a aidé à la rédaction ; le professionnel reste responsable du contenu.

Exemple – Vérifier un texte produit par une IA

Un outil propose pour une affiche : « Les adultes doivent manger 5 fruits par jour, boire 3 litres d'eau et éviter totalement le sucre. » Vérification avec les recommandations de Santé publique France (2019) : le repère est **au moins 5 fruits et légumes** par jour (et non 5 fruits) ; la quantité d'eau n'est pas fixée à 3 litres pour tous, on recommande de boire de l'eau à volonté, les besoins variant selon la personne, la chaleur et l'activité ; il est conseillé de **limiter** les produits sucrés et les boissons sucrées, pas de supprimer tout sucre. Trois erreurs en une phrase : le texte ne peut pas être utilisé sans correction.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.34

Une collègue a demandé à un outil d'IA un « menu type pour une famille musulmane pendant le ramadan ». La réponse présente un menu unique, très riche en fritures et en pâtisseries, comme « le menu traditionnel ». Relevez deux problèmes et proposez une meilleure façon de préparer ce support.

Corrigé

Problèmes : stéréotype culturel (un menu unique présenté comme « traditionnel » alors que les habitudes varient selon les pays, les régions et les familles) ; message implicitement jugeant sur la qualité de cette alimentation ; informations non vérifiées. Meilleure démarche : construire le support avec des familles concernées ou une médiatrice, partir de leurs plats habituels, valoriser ce qui est déjà favorable (soupes, dattes, légumineuses, eau), proposer des adaptations choisies (cuissons, hydratation, répartition sur la soirée), et vérifier les repères dans des sources officielles.

6.4.5 Le consentement des personnes vulnérables

Certaines personnes ont une capacité de décision limitée ou fluctuante : enfants, personnes âgées présentant des troubles cognitifs, personnes en situation de handicap intellectuel, personnes sous mesure de protection (tutelle, curatelle). Le principe reste de **rechercher leur adhésion** (assentiment), avec une information adaptée (FALC, chapitre 5), et d'associer, selon le cas, les représentants légaux, la personne de confiance ou l'entourage. On ne fait jamais participer quelqu'un « parce que c'est bon pour lui » contre son refus exprimé.

Les mesures de protection juridique des majeurs

Certaines personnes majeures ne peuvent plus pourvoir seules à leurs intérêts en raison d'une altération de leurs facultés (maladie, handicap, troubles cognitifs). Le juge des contentieux de la protection peut alors prononcer une mesure de protection. Le diététicien doit savoir de quoi il s'agit, car la mesure ne supprime **pas** les droits de la personne sur les décisions qui touchent à sa vie personnelle, dont son alimentation.

Mesure	Principe	Ce que cela signifie pour l'alimentation et la santé
Sauvegarde de justice	Protection temporaire et légère ; la personne conserve l'exercice de ses droits	Elle décide seule

Mesure	Principe	Ce que cela signifie pour l'alimentation et la santé
Curatelle	La personne est assistée par un curateur pour les actes importants, surtout financiers	Elle prend elle-même les décisions relatives à sa personne, y compris sur ses repas et ses soins, après information
Tutelle	La personne est représentée par un tuteur pour les actes de la vie civile	Pour les décisions relatives à sa personne, elle décide seule dans la mesure où son état le permet ; sinon, le juge peut prévoir l'assistance ou la représentation du tuteur, en tenant compte de son avis
Habilitation familiale	Un proche (enfant, conjoint, frère ou sœur) est autorisé par le juge à représenter ou assister la personne	Même principe : l'avis de la personne est recherché et respecté autant que possible

Le Code civil prévoit que la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne **dans la mesure où son état le permet**, et que la protection est exercée dans le respect de ses droits et de sa **dignité**. Une famille ou un tuteur ne peut donc pas imposer un régime alimentaire restrictif à un adulte qui peut exprimer ses choix.

Exemple – Un adulte sous curatelle et le choix de ses repas

M. A., 45 ans, vit dans un foyer pour adultes en situation de handicap et bénéficie d'une curatelle. Son curateur demande qu'on lui supprime les desserts, car il a pris du poids. La curatelle porte sur la gestion de ses biens, pas sur ses choix de vie quotidienne : la diététicienne explique au curateur que la décision appartient à M. A. Elle propose à M. A. un entretien pour parler de ce qui est important pour lui, des desserts qu'il aime, et des petits changements qu'il souhaiterait (fruits au goûter, desserts maison moins sucrés), en lien avec le médecin du foyer.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.4 – Approfondissements

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois rubriques d'une charte éditoriale pour un compte de prévention.
2. Avec la grille de partenariat, que décide-t-on si un critère « données » obtient 0 point ?
3. Quels sont les trois niveaux de l'échelle d'Arnstein ?
4. Que doit-on indiquer aux personnes qui échangent avec un agent conversationnel, selon le règlement européen sur l'IA ?
5. Un curateur peut-il décider à la place d'une personne de ce qu'elle mange ?
6. Une proposition apporte 900 € sur un budget de 6 000 €. Quelle part du budget représente-t-elle ?

Corrigé – Point d'étape 6.4

1. Objectif, public, sources autorisées, ce que l'on ne publie pas, validation, modération, partenariats, données.
2. On refuse la proposition.
3. Non-participation, participation symbolique, pouvoir effectif des citoyens.
4. Qu'elles échangent avec une IA.
5. Non : la curatelle porte surtout sur les actes financiers importants ; la personne décide elle-même de sa vie quotidienne.
6. 900 / 6 000 × 100 = 15 %.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie « Pour aller plus loin ».

6.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Justice sociale et capabilités

Deux grandes théories éclairent le principe de justice en santé publique. **John Rawls** (*Théorie de la justice*, 1971) propose que les inégalités ne soient acceptables que si elles profitent aux plus défavorisés (principe de différence). **Amartya Sen** et **Martha Nussbaum** développent l'approche par les **capabilités** : ce qui compte n'est pas seulement les ressources (revenu, informations), mais la **liberté réelle** des personnes de les convertir en états de santé (savoir cuisiner, avoir un équipement, du temps, un environnement favorable). Cette approche justifie d'agir sur les **environnements** et sur les **compétences**, pas seulement sur l'information.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le débat sur le paternalisme en santé publique

Les mesures nutritionnelles contraignantes (taxes, interdictions publicitaires, logos obligatoires) sont parfois critiquées comme **paternalistes** : l'État déciderait à la place des individus. Les défenseurs répondent que les choix alimentaires sont déjà fortement orientés par le marketing et l'environnement, et que la régulation **rétablit** des conditions de choix plus libres ; ils invoquent aussi l'**équité** (les mesures structurelles bénéficient davantage aux personnes défavorisées) et la protection des **enfants**. L'éthique de santé publique ne tranche pas a priori : elle exige une justification au cas par cas (efficacité, proportionnalité, nécessité, moindre atteinte, transparence).

Pour aller plus loin – niveau L3 – L'éthique du care

Développée par Carol Gilligan (*Une voix différente*, 1982) et Joan Tronto, l'éthique du **care** (« prendre soin ») insiste sur l'**attention** aux besoins concrets, la **responsabilité**, la **compétence** et la **réceptivité** des personnes aidées. Elle complète les principes abstraits par une attention à la **relation** et à la vulnérabilité, particulièrement pertinente auprès des personnes âgées isolées, des personnes précaires ou en situation de handicap.

Pour aller plus loin – niveau L3 – L'éthique de la discussion et la délibération

Le philosophe Jürgen **Habermas** a développé une **éthique de la discussion** : une norme est légitime si elle peut être acceptée par toutes les personnes concernées à l'issue d'une discussion libre et argumentée. Appliquée à la santé publique, cette approche justifie la **délibération** avec les usagers et les citoyens (démocratie en santé, conseils de la vie sociale, jurys citoyens, conventions citoyennes) avant des décisions qui touchent leur vie quotidienne, comme l'organisation des repas ou les mesures nutritionnelles contraignantes.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Justice alimentaire et démocratie alimentaire

Le mouvement de la **justice alimentaire**, né aux États-Unis dans les années 1990, part d'un constat : l'accès à une alimentation saine, durable et culturellement adaptée est inégalement réparti selon le revenu, le quartier et l'origine. Il ne s'agit pas seulement de distribuer de la nourriture, mais de transformer les systèmes alimentaires pour que chacun puisse choisir. En France, la notion de **démocratie alimentaire** prolonge cette idée : les citoyens devraient pouvoir participer aux décisions sur ce qui est produit, distribué et mangé sur leur territoire. Plusieurs expérimentations locales de « sécurité sociale de l'alimentation » (caisses alimentaires communes alimentées par des cotisations et gérées par des comités citoyens, depuis le début des années 2020) s'inscrivent dans cette réflexion ; leurs résultats sont encore en cours d'évaluation. Pour le

diététicien, cette approche invite à dépasser l'éducation individuelle pour agir aussi sur l'offre (épiceries solidaires, restauration collective, circuits courts accessibles) et sur la gouvernance (projets alimentaires territoriaux, conseils locaux de l'alimentation).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Une seule santé : l'éthique au-delà de l'humain

L'approche **Une seule santé** (*One Health*), promue par l'OMS, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation mondiale de la santé animale et le Programme des Nations unies pour l'environnement, considère que la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes sont étroitement liées. Elle élargit la réflexion éthique en nutrition : un régime alimentaire peut être favorable à la santé d'une personne mais coûteux pour l'environnement (forte consommation de produits animaux, gaspillage), ou au contraire durable mais inaccessible financièrement. Elle pose des questions de **justice entre générations** (que laissons-nous aux générations futures ?) et de **justice mondiale** (qui supporte les coûts environnementaux de notre alimentation ?). Les recommandations alimentaires françaises de 2019 intègrent déjà certains de ces enjeux (privilégier les produits de saison, les légumineuses, limiter la charcuterie et la viande hors volaille). L'enjeu éthique est de ne pas faire porter l'effort sur les plus modestes, pour qui le prix reste le premier critère de choix.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Autonomie relationnelle et vulnérabilité

La conception classique de l'autonomie imagine un individu rationnel qui décide seul, après information. Des philosophes, notamment dans le courant féministe (Catriona Mackenzie et Natalie Stoljar, *Relational Autonomy*, 2000), proposent la notion d'**autonomie relationnelle** : nos capacités de choisir se construisent dans nos relations et dépendent de nos conditions de vie. Une personne isolée, précaire ou dépendante n'a pas les mêmes possibilités de choix qu'une autre, même si elle est parfaitement informée. Respecter son autonomie, c'est alors aussi **renforcer ses capacités** (pouvoir d'agir, ressources, soutien social), ce qui rejoint la notion d'*empowerment* de la promotion de la santé et l'approche par les capabilités d'Amartya Sen.

6.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Secret et entourage

La fille d'une patiente âgée appelle le diététicien pour connaître « ce que maman a dit en consultation ». Il ne transmet rien sans l'accord de la patiente, propose une consultation à trois si la patiente le souhaite.

Situation bc2 – Allergies et données

En restauration scolaire, la liste des enfants allergiques (projets d'accueil individualisés) est une donnée de santé : elle est accessible aux seuls agents qui en ont besoin, n'est pas affichée nominativement en salle de restauration et est mise à jour chaque année.

Situation bc3 – Une campagne choc ?

Une mairie veut une affiche « Stop à l'obésité de nos enfants » avec une photo d'enfant en surpoids. Le diététicien argumente (non-malfaisance, stigmatisation, inefficacité) et propose une affiche positive centrée sur les goûters et le jeu.

Situation bc3 – Un financement à analyser

Un fabricant de boissons propose de financer un tournoi sportif « bien manger, bien bouger » dans un collège. Le diététicien analyse le conflit d'intérêts, informe le chef d'établissement et propose des financements alternatifs (ARS, collectivité, mutuelle).

Situation bc2 – Une allégation sur le menu

Un prestataire propose d'afficher « menu riche en protéines » au self d'un EHPAD. Le diététicien vérifie la composition (part de l'énergie apportée par les protéines) et préfère un affichage factuel et compréhensible, sans allégation non justifiée.

Situation bc3 – Une allergie en atelier

Une participante présente des démangeaisons après une dégustation. Le diététicien applique le protocole (arrêt, appel du 15 en cas de signe de gravité, information de la structure), puis analyse l'incident : l'allergie n'avait pas été déclarée ; la fiche d'inscription est complétée par une question orale à chaque séance.

Méthodes pour l'épreuve E5 : réussir les questions d'éthique

Les questions d'éthique et de cadre juridique sont présentes dans la plupart des sujets de l'épreuve E5, souvent sous la forme : « Identifiez les enjeux éthiques », « Proposez une conduite à tenir », « Justifiez au regard de la réglementation », « Analysez la proposition de partenariat ». Les méthodes suivantes permettent de répondre de façon structurée.

Méthode 1 – Identifier les enjeux éthiques d'une situation en cinq minutes

1. Repérer les personnes concernées : public, familles, professionnels, partenaires, financeurs.

2. Repérer les « mots signaux » dans le document : photo, questionnaire, nom, poids, logo, gratuit en échange de, confidence, enfant, obligatoire, liste, réseau social.

3. Associer chaque mot signal à une notion : photo, droit à l'image ; questionnaire nominatif, RGPD ; logo, conflit d'intérêts ; confidence, secret ; obligatoire, autonomie ; poids, non-malfaisance et stigmatisation ; public modeste, justice.

4. Rédiger un enjeu par paragraphe : notion, élément précis du document, risque concret, piste de solution.

Méthode 2 – Justifier par un texte sans se tromper

Citez le texte avec son **nom** et sa **date** quand vous en êtes sûr (« le RGPD, applicable depuis le 25 mai 2018 » ; « l'article 9 du Code civil »). Si vous n'êtes pas sûr du numéro d'article, citez le principe et le texte général (« le secret professionnel prévu par le Code pénal »). Une référence fausse affaiblit la copie ; une référence générale exacte suffit souvent. Ajoutez toujours **l'application concrète** à la situation : le jury évalue la capacité à utiliser la règle, pas seulement à la réciter.

Formulation de la question	Ce qui est attendu
« Identifiez »	Une liste organisée d'enjeux, chacun relié à un élément du document
« Analysez »	Les enjeux, leurs causes, leurs conséquences et les tensions entre principes
« Justifiez »	Un argument fondé sur un principe ou un texte, appliqué à la situation

Formulation de la question	Ce qui est attendu
« Proposez une conduite à tenir »	Des actions concrètes, ordonnées, réalistes (qui, quoi, quand)
« Rédigez » (un courrier, une note, une réponse)	Un texte prêt à l'emploi, adapté au destinataire, poli et clair

Exemple – Un paragraphe d'enjeu bien construit

« **Droit à l'image** : le document 3 indique que les photos de l'atelier seront publiées sur le compte du centre social. Or seuls 9 participants sur 14 ont signé une autorisation, soit 64,3 %. Publier des photos où l'on reconnaît les autres porterait atteinte à leur vie privée (article 9 du Code civil). Il faut donc ne publier que des photos des personnes qui ont autorisé ce support, ou des photos de mains et de plats. »

Ce paragraphe nomme la notion, s'appuie sur un chiffre du document, calcule, cite le texte, et propose une solution.

Méthode 3 – Rédiger un courrier de refus de partenariat

1. Remercier pour la proposition.

2. Rappeler l'objectif du projet et ses principes (indépendance, absence de publicité, protection des données).

3. Énoncer le refus clairement, sans agressivité ni jugement sur l'entreprise.

4. Proposer éventuellement une alternative acceptable (soutien sans contrepartie, mécénat anonyme), si elle existe.

5. Formule de politesse adaptée.

Méthode 4 – Préparer l'oral : défendre la dimension éthique de son projet

Le jury peut demander : « Quelles précautions éthiques avez-vous prises ? » Préparez une réponse en six points, chacun illustré par un fait de votre projet : **confidentialité** (cadre énoncé, données agrégées), **données** (questionnaire anonyme, durée de conservation), **image** (autorisations, photos sans visage), **partenariat** (refus ou convention), **non-stigmatisation** (vocabulaire, absence de pesée), **participation** (choix des recettes avec le public). Ayez en tête un **dilemme vécu** et la façon dont vous l'avez résolu avec votre tuteur : c'est souvent la question qui fait la différence.

Méthode 5 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve

Point d'étape – Vrai ou faux ? Justifiez chaque réponse en une phrase

1. Un questionnaire sans nom est toujours anonyme.
2. Le secret professionnel s'arrête quand la personne a elle-même parlé publiquement de sa situation.
3. Un stagiaire n'a pas à respecter la confidentialité, car il n'est pas encore professionnel.
4. Le consentement d'un salarié à une enquête demandée par son employeur est une base légale solide.
5. Un parent seul peut autoriser la diffusion de la photo de son enfant sur un réseau social.
6. Un lien d'intérêts est une faute professionnelle.
7. Un nudge interdit les choix défavorables à la santé.
8. Un aliment peut annoncer qu'il prévient le cancer s'il est riche en fibres.
9. Les compléments alimentaires sont autorisés comme des médicaments avant leur mise sur le marché.
10. Une évaluation de la satisfaction d'un atelier relève de la loi Jardé.
11. Une violation de données doit être notifiée à la CNIL dans les 72 heures, sauf absence de risque pour les personnes.

12. La nutrition artificielle est considérée comme un traitement par la loi.
13. Un tuteur peut imposer un régime alimentaire à une personne protégée capable d'exprimer ses choix.
14. Le titre de nutritionniste est protégé comme celui de diététicien.
15. Un professionnel de santé peut accepter un repas offert par un laboratoire pharmaceutique s'il assiste à une présentation de produits.

Corrigé – Vrai ou faux

1. Faux : le croisement de plusieurs informations (âge, classe, quartier) peut permettre d'identifier une personne, surtout dans un petit groupe.
2. Faux : le professionnel reste tenu au secret, même si la personne a parlé (exemple de l'avis en ligne).
3. Faux : il est tenu à la discrétion et à la confidentialité par sa convention de stage et la déontologie.
4. Faux : le salarié n'est pas vraiment libre de refuser ; on s'appuie sur une autre base légale.
5. Faux : l'accord des deux titulaires de l'autorité parentale est nécessaire, et l'enfant est associé selon son âge.
6. Faux : c'est l'absence de déclaration et de gestion qui pose problème.
7. Faux : le nudge oriente sans rien interdire.
8. Faux : aucun aliment ne peut prétendre prévenir ou guérir une maladie, sauf allégation de réduction d'un risque autorisée au cas par cas.
9. Faux : ils sont déclarés, mais ne font pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché comme un médicament.
10. Faux : il s'agit d'une évaluation d'action, soumise au RGPD si des données personnelles sont recueillies.
11. Vrai : article 33 du RGPD.
12. Vrai : loi du 2 février 2016.
13. Faux : la personne protégée décide de sa vie personnelle dans la mesure où son état le permet.
14. Faux : seul le titre de diététicien (et celui de médecin nutritionniste) est protégé.
15. Faux : un avantage sans contrepartie professionnelle réelle est interdit par l'encadrement des avantages.

Mon score	Ce que je fais
13 à 15 sur 15	Je passe à l'entraînement de la partie 6.8.
9 à 12 sur 15	Je relis les parties correspondant à mes erreurs.
Moins de 9 sur 15	Je relis l'essentiel à retenir et les points d'étape avant l'entraînement.

Méthode 6 – Relier l'éthique aux autres chapitres du cours

Notion du chapitre 6	Chapitre lié	Ce qu'il faut relier
Justice, universalisme proportionné	Chapitre 2 (déterminants et inégalités sociales de santé)	Ne pas creuser les inégalités, cibler sans stigmatiser
Stigmatisation, culpabilisation	Chapitres 3 et 4 (représentations, comportements alimentaires)	Restriction cognitive, vocabulaire moral, préjugés
Information loyale, consentement éclairé	Chapitre 5 (littératie en santé)	Écrire clair, « faire dire », précautions universelles
Questionnaires, RGPD, petits effectifs	Chapitre 9 (évaluation)	Minimisation, anonymat, analyse des limites
Démarche de projet	Chapitres 1, 7 et 8 (santé publique, démarche de projet)	La dimension éthique accompagne chaque étape du projet

Notion du chapitre 6	Chapitre lié	Ce qu'il faut relier
Allégations, marketing	Chapitre 5 (lecture d'étiquettes)	Littératie critique face aux emballages
Sécurité des ateliers, TIAC	Chapitre 13 du volume 2 (hygiène et sécurité alimentaire)	Allergènes, chaîne du froid, déclaration à l'ARS

Méthode 7 – Savoir à qui s'adresser : les autorités et leurs rôles

Une question fréquente à l'épreuve est : « À qui signaler ? » ou « Quel organisme contrôle ? ». Le tableau suivant rassemble les principales autorités citées dans le chapitre.

Autorité	Statut	Rôle utile au diététicien	Exemple de saisine
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), créée en 1978	Autorité administrative indépendante	Conseille, contrôle et sanctionne en matière de données personnelles ; reçoit les notifications de violation et les plaintes	Une structure notifie la perte d'un fichier ; une personne se plaint d'une collecte abusive
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), avec les directions départementales de la protection des populations	Administration de l'État	Contrôle l'étiquetage, les allégations, la publicité, les pratiques commerciales trompeuses et l'influence commerciale	Signalement d'une allégation interdite (plateforme SignalConso)
Agence régionale de santé (ARS)	Établissement public de l'État	Pilote la santé publique en région ; reçoit les déclarations obligatoires (dont les TIAC) ; enregistre les diplômes des professionnels de santé	Déclaration d'une toxi-infection alimentaire collective
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses)	Établissement public	Évalue les risques ; publie les références nutritionnelles ; gère la nutrivigilance	Déclaration d'un effet indésirable lié à un complément alimentaire
Défenseur des droits, institué en 2011	Autorité constitutionnelle indépendante	Défend les droits des usagers des services publics, lutte contre les discriminations, défend les droits de l'enfant	Une famille estime que son enfant a été exclu de la cantine de façon discriminatoire
Cellule départementale de recueil des informations préoccupantes (CRIP)	Service du conseil départemental	Recueille et évalue les informations préoccupantes concernant les mineurs en danger ou en risque de l'être	Information préoccupante sur un enfant qui semble négligé
Procureur de la République	Magistrat	Reçoit les signalements de danger grave et immédiat et les plaintes pénales	Signalement d'un enfant victime de violences
Comité de protection des personnes (CPP)	Comité indépendant agréé	Rend un avis sur les recherches impliquant la personne humaine	Dépôt d'un protocole de recherche en nutrition

Définition – Sanction administrative et sanction pénale

Une **sanction administrative** est prononcée par une autorité administrative (amende de la CNIL, fermeture d'un établissement par le préfet après un contrôle d'hygiène). Une **sanction pénale** est prononcée par un tribunal pour une infraction prévue par la loi (contravention, délit ou crime) : amende pénale, emprisonnement. La violation du secret professionnel, l'usurpation de titre et la discrimination sont des

délits, jugés par le tribunal correctionnel.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.35

Indiquez l'autorité à saisir dans chaque situation : a) un yaourt « brûleur de graisses » en rayon ; b) huit élèves malades après un pique-nique scolaire ; c) une association a publié en ligne le fichier nominatif des bénéficiaires de son épicerie ; d) une participante présente des palpitations après un complément « minceur » ; e) une personne en situation de handicap se voit refuser l'accès à un atelier cuisine.

Corrigé

a) DGCCRF (direction départementale de la protection des populations), par exemple via SignalConso. b) ARS : déclaration obligatoire d'une toxi-infection alimentaire collective, par le médecin ou le responsable. c) CNIL : notification de la violation par l'association dans les 72 heures ; les personnes concernées peuvent aussi porter plainte. d) Nutrivigilance de l'Anses, par un professionnel de santé, après orientation médicale. e) Défenseur des droits (discrimination fondée sur le handicap), et éventuellement plainte pénale.

6.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Notions et principes

- **Morale** (valeurs) · **éthique** (réflexion face à une situation) · **déontologie** (devoirs professionnels) · **droit** (règles sanctionnées).
- **Quatre principes** (Beauchamp et Childress, 1979) : autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice.
- **Santé publique** (Childress, 2002) : efficacité, proportionnalité, nécessité, moindre atteinte, justification publique ; **échelle d'intervention** (Nuffield, 2007) ; **nudge** (Thaler et Sunstein, 2008) : transparence, réversibilité.
- **Non-stigmatisation** : parler de comportements et d'environnements, images respectueuses, pas de pesée en public, pas de vocabulaire moral.

À retenir – Règles

- Profession réglementée : **L. 4371-1 CSP** (inclut la prévention en santé publique) ; titre protégé ; enregistrement ; code de déontologie AFDN.
- **Secret** : L. 1110-4 CSP ; **226-13 Code pénal** (1 an, 15 000 €) ; données agrégées ; protection de l'enfance (CRIP, 119).
- **RGPD** (2016/679, 25 mai 2018) : licéité-transparence, finalité, minimisation, exactitude, conservation limitée, sécurité + responsabilité ; données de santé = catégorie particulière ; anonymiser ; sanction jusqu'à 20 M€ ou 4 % du CA (le plus élevé).
- **Image** : article 9 Code civil ; autorisation écrite, par support ; mineur : deux titulaires de l'autorité parentale.
- **Conflits d'intérêts** : repérer, déclarer, gérer ; Code OMS 1981 (substituts du lait maternel) ; loi du 29 décembre 2011 (Transparence Santé).
- **Démarche** : faits → règles → valeurs → options → décision justifiée et tracée.

À retenir – Compléments : droits, responsabilité, allégations, recherche, numérique

- **Droits** : DUDH art. 25 ; loi du 2 janvier 2002 (CVS, charte de la personne accueillie) ; loi du 4 mars 2002 ;

EGalim : précarité alimentaire, dignité, capacité à agir (L. 266-1 CASF) ; démocratie en santé.

- **Responsabilité** : civile (faute, dommage, lien ; assurance), pénale (infraction), disciplinaire ; TIAC = maladie à déclaration obligatoire ; stagiaire sous la responsabilité du tuteur (convention).
- **Allégations** (règlement 1924/2006) : source de fibres ≥ 3 g/100 g ; riche ≥ 6 g/100 g ; source de protéines ≥ 12 % de l'énergie ; allégé ≥ − 30 % ; contrôle par la DGCCRF.
- **Publicité** : messages sanitaires obligatoires (2004-2007) ; **compléments** : décret 2006-352, nutrivigilance (ANSES).
- **Enquêtes** : questionnaire d'évaluation hors loi Jardé ; RIPH : CPP ; MR-004 pour les études sur données existantes.
- **Numérique** : identité numérique, e-réputation ; IA : confidentialité, vérification, responsabilité, intégrité académique.

6.8 Entraînement

6.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – La déontologie :

a) rassemble les devoirs d'une profession **b)** est une réflexion philosophique générale **c)** est formalisée pour les diététiciens par un code porté par l'AFDN **d)** est toujours sanctionnée pénalement

QCM 2 – Les quatre principes de Beauchamp et Childress sont :

a) autonomie **b)** bienfaisance **c)** rentabilité **d)** justice

QCM 3 – Le principe de non-malfaisance en nutrition invite à :

a) éviter la stigmatisation du poids **b)** multiplier les pesées publiques **c)** éviter d'induire une restriction cognitive **d)** culpabiliser pour motiver

QCM 4 – Sur l'échelle d'intervention du Nuffield Council :

a) informer est peu intrusif **b)** la taxe sur les boissons sucrées est une désincitation **c)** l'interdiction des distributeurs dans les écoles restreint le choix **d)** plus l'intervention est intrusive, moins elle doit être justifiée

QCM 5 – Un nudge :

a) interdit certaines options **b)** modifie l'architecture du choix **c)** doit, pour être éthique, rester transparent et réversible **d)** a été popularisé par Thaler et Sunstein

QCM 6 – L'article L. 4371-1 du CSP :

a) définit la profession de diététicien **b)** mentionne les activités de prévention en santé publique **c)** crée un ordre des diététiciens **d)** concerne le secret médical uniquement

QCM 7 – La violation du secret professionnel est punie de :

a) 6 mois et 7 500 € **b)** 1 an et 15 000 € **c)** 5 ans et 75 000 € **d)** une simple amende

QCM 8 – Le RGPD :

a) est le règlement (UE) 2016/679 **b)** est applicable depuis le 25 mai 2018 **c)** ne concerne que les entreprises **d)** classe les données de santé en catégorie particulière

QCM 9 – Le principe de minimisation signifie :

a) collecter le moins de personnes possible **b)** collecter seulement les données nécessaires à la finalité **c)** réduire la taille des fichiers **d)** supprimer les questions sans rapport avec l'objectif

QCM 10 – Des données pseudonymisées :

a) sont des données anonymes **b)** restent des données personnelles **c)** peuvent être réidentifiées avec une clé **d)** échappent au RGPD

QCM 11 – Pour photographier un enfant de 8 ans lors d'un atelier :

a) l'accord oral de l'animateur suffit **b)** il faut l'autorisation écrite des titulaires de l'autorité parentale **c)** il est conseillé de recueillir aussi l'avis de l'enfant **d)** aucune autorisation n'est nécessaire dans un lieu public

QCM 12 – Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel :

a) a été adopté par l'OMS en 1981 **b)** autorise la distribution d'échantillons aux parents **c)** encadre la promotion des laits infantiles **d)** concerne uniquement les hôpitaux

QCM 13 – Un conflit d'intérêts :

a) est toujours une faute **b)** peut exister même si le jugement n'est pas réellement influencé **c)** doit être déclaré et géré **d)** concerne uniquement les intérêts financiers

QCM 14 – Un participant confie en atelier qu'il est diabétique. Vous :

a) le signalez à la structure **b)** respectez la confidentialité **c)** pouvez lui proposer en privé une orientation **d)** l'annoncez au groupe pour adapter la recette

QCM 15 – Dans un service public, le stagiaire :

a) respecte un devoir de neutralité religieuse et politique **b)** peut promouvoir ses convictions **c)** respecte les pratiques religieuses des usagers **d)** impose un menu unique sans adaptation

> **Corrigé – Corrigé expliqué des QCM**
>
> **1. a, c**. 2. **a, b, d** (+ non-malfaisance). 3. **a, c**. 4. **a, b, c** (d est faux : la justification doit croître). 5. **b, c, d**. 6. **a, b**. 7. **b** (article 226-13 du Code pénal). 8. **a, b, d**. 9. **b, d**. 10. **b, c**. 11. **b, c**. 12. **a, c**. 13. **b, c**. 14. **b, c** (on peut adapter la recette sans désigner la personne). 15. **a, c**.

QCM 16 – Le conseil de la vie sociale :

a) existe dans les établissements sociaux et médico-sociaux **b)** associe résidents, familles et personnel **c)** a été créé par la loi du 2 janvier 2002 **d)** remplace le médecin coordonnateur

QCM 17 – Une toxi-infection alimentaire collective :

a) concerne au moins deux cas groupés liés à une même origine alimentaire **b)** est une maladie à déclaration obligatoire **c)** se déclare à l'ARS **d)** ne concerne que les restaurants

QCM 18 – L'allégation « riche en fibres » suppose au moins :

a) 3 g de fibres pour 100 g **b)** 6 g de fibres pour 100 g **c)** 3 g de fibres pour 100 kcal **d)** 1,5 g de fibres pour 100 kcal

QCM 19 – La responsabilité civile :

a) oblige à réparer un dommage **b)** suppose une faute, un dommage et un lien de causalité **c)** est couverte par une assurance **d)** entraîne une peine de prison

QCM 20 – La méthodologie de référence MR-004 de la CNIL concerne :

a) les recherches n'impliquant pas la personne humaine **b)** les études et évaluations à partir de données existantes **c)** les essais de médicaments **d)** les sites internet

> **Corrigé – Corrigé expliqué des QCM complémentaires**
>
> **16. a, b, c**. 17. **a, b, c**. 18. **b, c** (l'une ou l'autre condition). 19. **a, b, c**. 20. **a, b**.

6.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les quatre principes

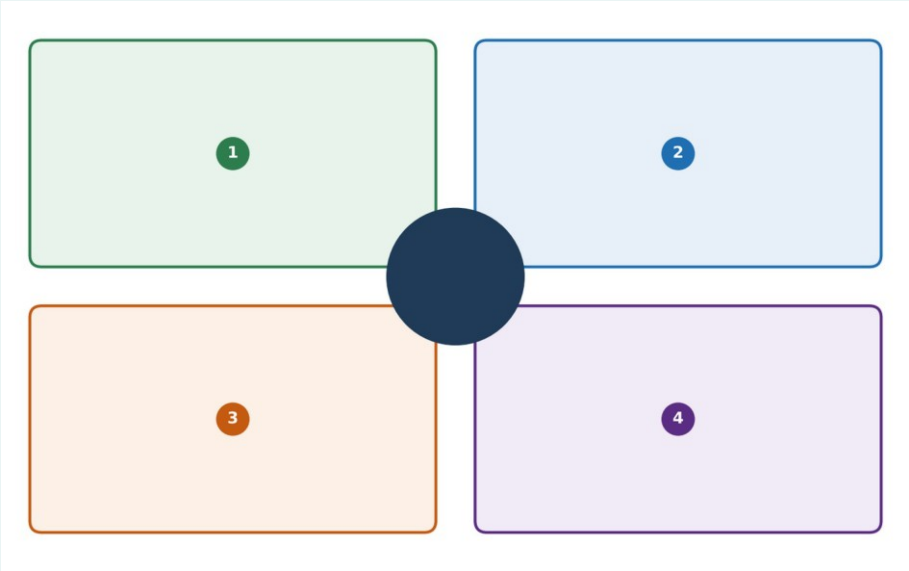


Figure 6.6 – Schéma à légender

Légendez les principes 1 à 4 et illustrez chacun par un exemple tiré d'un atelier culinaire.

Corrigé

1. Autonomie : chacun choisit de goûter ou non, de participer ou non. 2. **Bienfaisance** : recettes fondées sur les repères, utiles au budget. 3. **Non-malfaisance** : pas de commentaires sur le poids, vérification des allergies. 4. **Justice** : atelier gratuit, horaires compatibles avec les contraintes des familles, priorité au quartier prioritaire.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : l'échelle d'intervention

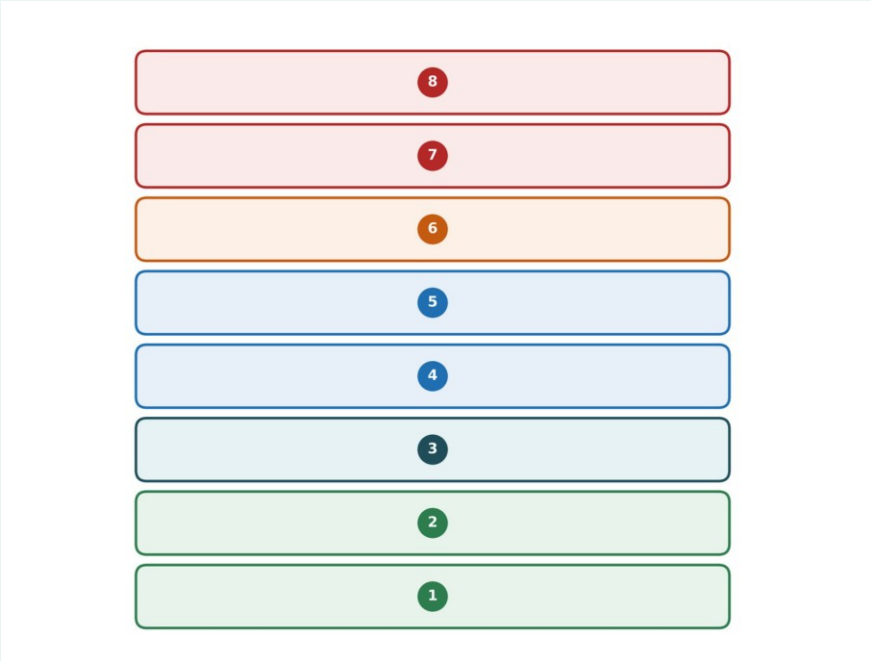


Figure 6.7 – Schéma à légender

Nommez les échelons 1 à 8 et placez les mesures suivantes : a) eau servie en carafe au restaurant scolaire ; b)

chèques « fruits et légumes » ; c) campagne d'affichage ; d) interdiction de la publicité pour les produits gras-sucrés-salés pendant les programmes jeunesse (proposition).

Corrigé

1. Ne rien faire ou surveiller. 2. Informer, éduquer. 3. Faciliter les choix. 4. Orienter par défaut. 5. Inciter. 6. Désinciter. 7. Restreindre les choix. 8. Éliminer le choix. Placement : a) **4** ; b) **5** ; c) **2** ; d) **7**.

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : le RGPD

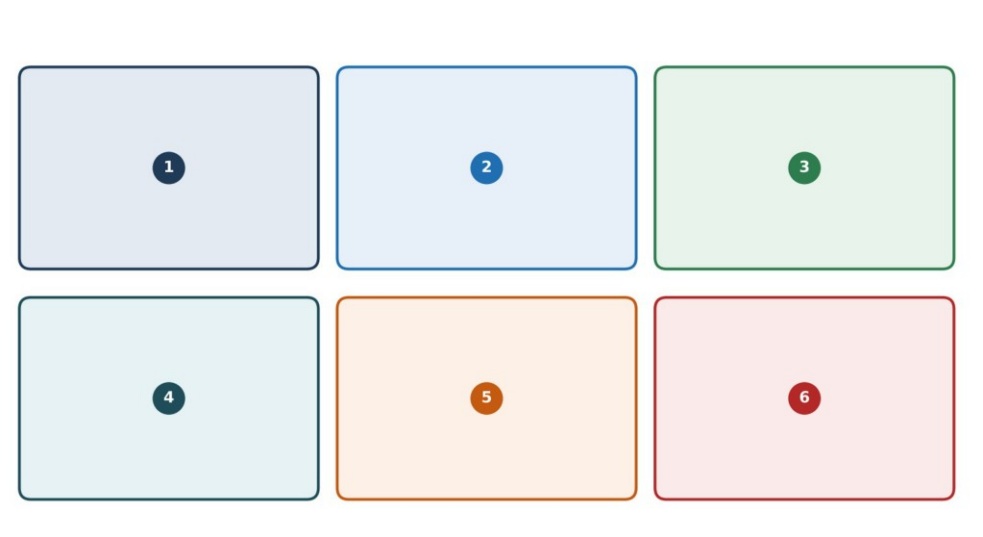


Figure 6.8 – Schéma à légender

Légendez les principes 1 à 6 et, pour chacun, indiquez une mesure concrète pour un questionnaire d'évaluation d'atelier.

Corrigé

1. Licéité, loyauté, transparence : mention d'information en tête. 2. **Finalité** : servir uniquement à évaluer l'atelier. 3. **Minimisation** : pas de nom, âge en tranches. 4. **Exactitude** : saisie vérifiée par double contrôle.

5. Conservation limitée : suppression à une date fixée. 6. **Intégrité et confidentialité** : fichier protégé, questionnaires détruits après saisie.

À vous de jouer – Exercice 4 – Minimiser un questionnaire

Un questionnaire d'évaluation d'atelier demande : nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone, poids, taille, nombre d'enfants, satisfaction, recettes refaites. Supprimez les données inutiles et justifiez.

Corrigé

À supprimer : **nom, prénom, adresse, téléphone** (identifiants inutiles pour évaluer ; si un recontact est souhaité, liste séparée, facultative, avec consentement) ; **date de naissance** (remplacer par une tranche d'âge si utile) ; **poids et taille** (données de santé non nécessaires à l'évaluation d'un atelier, et stigmatisantes). À conserver : nombre d'enfants (si utile pour l'analyse), satisfaction, recettes refaites. Principe : **minimisation** et respect de la catégorie particulière des données de santé.

À vous de jouer – Exercice 5 – Calcul : taux d'autorisations

Sur 18 participants adultes, 13 ont signé l'autorisation de droit à l'image pour le dossier, 6 pour les réseaux sociaux. Sur 22 enfants, 9 autorisations sont signées par les deux parents et 4 par un seul parent. Calculez les taux et indiquez qui vous pouvez photographier pour chaque support.

Corrigé

Adultes, dossier : 13 / 18 × 100 = **72,2 %** ; réseaux sociaux : 6 / 18 × 100 = **33,3 %**. Enfants, autorisation complète : 9 / 22 × 100 = **40,9 %** ; autorisations incomplètes : 4 / 22 × 100 = **18,2 %** (à compléter avant utilisation, par prudence). On ne publie sur les réseaux que les 6 adultes concernés ; pour les enfants, uniquement les 9 autorisés, sinon photos sans visage.

À vous de jouer – Exercice 6 – Rédiger une mention d'information

Rédigez la mention d'information d'un questionnaire de diagnostic distribué à la sortie d'une école.

Corrigé

« Ce questionnaire est **anonyme** et **facultatif**. Il est réalisé par [prénom], étudiante en BTS Diététique et nutrition, en stage au centre social [nom], pour connaître les habitudes et les besoins des familles et construire des ateliers adaptés. Les réponses seront saisies puis les questionnaires détruits. Les résultats seront présentés de façon globale (aucune réponse individuelle). Le fichier sera supprimé le [date]. Questions : [contact de la référente]. Merci ! »

À vous de jouer – Exercice 7 – Analyser un partenariat

Une enseigne de restauration rapide propose 800 € pour financer un cycle d'ateliers « cuisine maison » si son logo figure sur les supports et si un bon de réduction est remis aux participants. Analysez et proposez une réponse.

Corrigé

Analyse : intérêt secondaire commercial en contradiction avec l'objectif (cuisine maison) ; bon de réduction = promotion directe auprès d'un public vulnérable ; risque de perte de crédibilité. **Réponse** : refuser les contreparties ; si l'entreprise accepte un mécénat sans logo ni bon, sans influence sur le contenu, convention écrite et mention transparente, la décision revient à la direction ; sinon, solliciter d'autres financeurs (CAF, ARS, collectivité, fondation).

À vous de jouer – Exercice 8 – Calcul de sanction et de date

a) Calculez le plafond d'amende RGPD pour une entreprise réalisant 650 M€ de chiffre d'affaires mondial. b) Des données recueillies le 12 octobre 2027 doivent être conservées 18 mois : à quelle date les supprimer ?

Corrigé

a) 4 % × 650 = 0,04 × 650 = **26 M€** ; 26 M€ > 20 M€ → plafond : **26 M€** (le plus élevé des deux). b) 12 octobre 2027 + 12 mois = 12 octobre 2028 ; + 6 mois = **12 avril 2029**.

À vous de jouer – Exercice 9 – Réécrire un message stigmatisant

Réécrivez l'accroche suivante : « Vos enfants sont trop gros ? Venez apprendre à les mettre au régime ! »

Corrigé

« Des goûters bons, simples et pas chers : venez cuisiner avec vos enfants ! » Le nouveau message parle de plaisir, de famille et de budget, ne cible pas le poids, ne propose pas de régime (non-malfaisance : risque de restriction chez l'enfant) et n'exclut personne.

À vous de jouer – Exercice 10 – Dilemme : la participante qui ne veut plus venir

Une participante a manqué trois ateliers ; la référente vous demande de l'appeler pour « la remettre dans le droit chemin », car son assiduité conditionne une aide du CCAS. Analysez avec la grille en 5 étapes.

Corrigé

Faits : absences ; lien entre participation et aide (conditionnalité). **Règles** : participation libre à une action de santé ; secret ; règlement du CCAS à vérifier. **Valeurs** : autonomie (liberté de participer) contre bienfaisance (maintenir le lien, l'aide) et justice (ne pas pénaliser une personne en difficulté). **Options** : a) appeler pour rappeler l'obligation (contrainte) ; b) ne rien faire ; c) appeler pour prendre des nouvelles, comprendre les obstacles (horaires, enfants, santé) et proposer des adaptations, en rappelant que la participation est libre ; signaler à la référente le problème éthique de la conditionnalité. **Décision** : option c, discutée avec la tutrice et tracée.

6.8.3 Questions de réflexion

À vous de jouer – Question 1

Une taxe sur les boissons sucrées est-elle éthiquement justifiable ?

Corrigé

On peut la justifier par l'**efficacité** (baisse des teneurs en sucre par reformulation après 2018, baisse des achats), la **gravité** du problème (obésité, caries, diabète), la **proportionnalité** (le choix reste possible) et la **justice** si les recettes financent la prévention ou l'accès à l'eau. Les objections sont la **régressivité** (elle pèse davantage, en proportion du revenu, sur les ménages modestes) et le paternalisme. La réponse dépend de la conception et de l'accompagnement de la mesure.

À vous de jouer – Question 2

Peut-on mener une action efficace sans parler du poids ?

Corrigé

Oui : les comportements (alimentation, activité physique, sommeil) et les environnements améliorent la santé indépendamment du poids, et les approches centrées sur le poids risquent la stigmatisation et la restriction. On peut évaluer des indicateurs de comportements, de compétences et de bien-être. Le suivi du poids relève, si nécessaire, du soin individuel.

À vous de jouer – Question 3

L'éthique est-elle une affaire de règles ?

Corrigé

Les règles (droit, déontologie) sont nécessaires mais ne suffisent pas : elles ne prévoient pas toutes les situations et peuvent entrer en conflit. L'éthique est une **démarche** de réflexion, de délibération collective et de justification, qui s'appuie sur les règles mais cherche la conduite la plus juste dans chaque cas.

6.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – Le défi « 10 000 pas » dans une entreprise

Une entreprise de 400 salariés lance un défi « 10 000 pas et zéro sucre » pendant un mois, avec classement nominatif affiché à la cafétéria, pesée volontaire au début et à la fin, et une application qui recueille les pas et les repas. Le service RH vous demande d'animer la partie alimentation.

1. Identifiez les enjeux éthiques (principes en tension).
2. Analysez la conformité au RGPD.
3. Quels risques pour la santé des salariés ?
4. Proposez une version éthique du projet.
5. Comment évaluer sans données individuelles de santé ?

Corrigé

1. Autonomie : volontariat réel dans un cadre hiérarchique ? Pression sociale du classement. **Non-malfaisance** : stigmatisation des moins performants, « zéro sucre » qui favorise la restriction. **Justice** : salariés en situation de handicap, de travail posté, exclus. **Bienfaisance** : promotion de l'activité physique, légitime.

2. Les pas, le poids et les repas sont des données personnelles, et le poids une donnée de santé ; l'employeur ne doit pas y accéder nominativement ; base légale, information, minimisation, durée, sécurité de l'application, analyse d'impact (AIPD) probablement nécessaire ; le consentement donné à l'employeur est fragile (lien de subordination).
3. Restriction cognitive, culpabilité, TCA chez des personnes vulnérables, blessures, stigmatisation, atteinte au climat de travail.
4. Défi **collectif** par équipes, sans classement nominatif ni pesée, objectifs adaptables à chacun ; ateliers « collations plaisir » et « eau au bureau » ; amélioration de l'environnement (fruits à la cafétéria, fontaines, escaliers mis en valeur) ; application facultative gérée par un tiers, données agrégées seulement.
5. Questionnaires anonymes avant/après (fréquence de consommation de boissons sucrées, satisfaction, ressenti), participation par équipe, consommation d'eau et de fruits à la cafétéria (ventes).

6.8.5 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Quelle différence entre éthique et déontologie ? »

Corrigé

La déontologie est l'ensemble des devoirs d'une profession, formalisés dans un code ; l'éthique est une réflexion sur les valeurs, face à une situation, pour décider de la conduite la plus juste, surtout quand les

règles ne suffisent pas ou se contredisent.

Mise en situation – MSE 2

Votre tutrice vous demande d'envoyer la liste des participants avec leurs pathologies sur votre messagerie personnelle pour que vous « travailliez le week-end ».

Corrigé

Je refuse poliment en expliquant les règles du RGPD (sécurité, données de santé) ; je propose de travailler sur des données anonymisées ou sur le poste sécurisé de la structure.

Mise en situation – MSE 3

Une mère veut filmer l'atelier pour sa page Facebook.

Corrigé

Je lui explique que d'autres personnes ont le droit de refuser d'être filmées ; je propose qu'elle filme uniquement son enfant (avec l'accord de l'autre parent si nécessaire) ou les plats, ou d'utiliser les photos autorisées par le centre social.

Mise en situation – MSE 4

Le jury : « Avez-vous rencontré un problème éthique pendant votre stage ? »

Corrigé

Je présente un exemple précis avec la démarche en 5 étapes : les faits, les règles, les valeurs en tension, les options envisagées et la décision prise avec ma tutrice, puis ce que j'en ai appris.

Mise en situation – MSE 5

Un laboratoire de compléments alimentaires vous propose d'animer un stand rémunéré lors de votre action.

Corrigé

Je refuse : conflit d'intérêts manifeste et risque de promotion commerciale auprès du public ; je rappelle l'indépendance de l'action et j'en informe ma tutrice.

Mise en situation – MSE 6

Un enfant vous dit pendant l'atelier qu'il « n'a pas mangé depuis hier » et semble inquiet.

Corrigé

Je lui propose discrètement à manger, je reste bienveillant(e), et j'en parle sans délai à la référente de la structure ; si la situation fait craindre un danger, la structure transmet une information préoccupante (CRIP) ; je ne mène pas d'enquête seul(e).

Mise en situation – MSE 7

Le jury : « Votre questionnaire était-il conforme au RGPD ? »

Corrigé

Oui : anonyme, facultatif, avec mention d'information, données minimisées (pas de poids ni de nom), finalité unique, questionnaires détruits après saisie, fichier protégé et date de suppression fixée.

Mise en situation – MSE 8

Une élue souhaite afficher les résultats de pesée des écoles par classe.

Corrigé

J'explique les risques de stigmatisation et la nature de données de santé ; je propose de présenter des données agrégées à l'échelle de la commune, issues de sources officielles, et de communiquer sur les actions plutôt que sur les corpulences.

Mise en situation – MSE 9

Le jury : « Qu'est-ce qu'un nudge ? Est-ce éthique ? »

Corrigé

C'est une modification de l'architecture du choix qui oriente sans interdire (fruits mis en avant au self). Il peut être éthique s'il est transparent, réversible, au service de la santé et équitable.

Mise en situation – MSE 10

Une participante demande votre numéro personnel pour vous poser des questions.

Corrigé

Je reste dans un cadre professionnel : je donne les coordonnées de la structure et les horaires où je suis joignable, et je l'oriente vers une consultation si ses questions sont individuelles.

Mise en situation – MSE 11

Le jury : « Que risque un professionnel qui viole le secret ? »

Corrigé

Un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende (article 226-13 du Code pénal), en plus des sanctions disciplinaires de son employeur et de la responsabilité civile.

Mise en situation – MSE 12

Une collègue utilise l'expression « les obèses du quartier » dans un compte rendu.

Corrigé

Je lui propose discrètement une formulation centrée sur les personnes et les déterminants (« les habitants concernés par le surpoids », « les familles du quartier ») en expliquant l'enjeu de stigmatisation.

6.8.6 Exercices complémentaires

À vous de jouer – Exercice 11 – Vérifier des allégations

Pour 100 g : pain de mie A : 270 kcal, fibres 3,4 g, protéines 8 g ; barre de céréales B : 410 kcal, fibres 6,5 g, protéines 6 g ; fromage blanc C : 75 kcal, protéines 7,5 g. Quelles allégations « fibres » et « protéines » sont possibles ?

Corrigé

A : fibres 3,4 g ≥ 3 g → « **source de fibres** » (pas « riche » : 3,4 < 6 ; 3,4 / 270 × 100 = 1,26 g pour 100 kcal < 3) ; protéines : 8 × 4 = 32 kcal ; 32 / 270 × 100 = **11,9 %** < 12 % → aucune allégation. B : fibres 6,5 ≥ 6 → « **riche en fibres** » ; protéines 6 × 4 / 410 × 100 = **5,9 %** → aucune. C : protéines 7,5 × 4 = 30 kcal ; 30 / 75 × 100 = **40 %** ≥ 20 % → « **riche en protéines** ».

À vous de jouer – Exercice 12 – Gérer un incident

Lors d'un atelier, deux participants présentent des troubles digestifs le lendemain d'une dégustation de mayonnaise maison. Décrivez la conduite à tenir.

Corrigé

Recenser les personnes malades et les symptômes (sans divulguer les noms), informer la structure et le médecin le cas échéant ; s'il s'agit d'au moins deux cas liés au même repas : suspicion de **TIAC**, déclaration à l'ARS par le médecin ou le responsable ; conserver les restes et noter les lots des produits (traçabilité) ; analyser les pratiques (œufs crus, conservation) ; ajuster les recettes (mayonnaise aux œufs pasteurisés ou consommation immédiate, chaîne du froid).

À vous de jouer – Exercice 13 – Classer des enquêtes

Indiquez le cadre applicable : a) questionnaire anonyme de satisfaction après des ateliers ; b) étude comparant la glycémie de 40 patients selon deux petits-déjeuners, en vue d'une publication ; c) analyse des dossiers diététiques d'un service hospitalier pour un mémoire ; d) questionnaire nominatif sur le poids des salariés d'une entreprise.

Corrigé

a) Hors loi Jardé ; RGPD allégé si anonyme (mention d'information). b) **RIPH** (intervention, prélèvements) : avis d'un CPP, consentement. c) Étude sur données existantes : **MR-004** ou autorisation, information des patients, accord de l'établissement. d) À **refuser ou revoir** : données de santé nominatives sans finalité légitime ni garanties ; risque de discrimination ; anonymiser et justifier ou supprimer (chapitre 6).

À vous de jouer – Exercice 14 – Dignité et aide alimentaire

Une association distribue des colis identiques et demande aux bénéficiaires de suivre un « cours de cuisine obligatoire » pour recevoir le colis. Analysez au regard de l'article L. 266-1 du CASF et proposez une

alternative.

Corrigé

La conditionnalité porte atteinte à la **liberté** et à la **dignité** ; les colis identiques ne respectent pas le **choix**. Alternative : épicerie solidaire avec choix des produits, atelier proposé librement, conçu avec les bénéficiaires, valorisant leurs savoir-faire ; participation à la gouvernance (comité de bénéficiaires).

À vous de jouer – Exercice 15 – Identité numérique

Une étudiante en stage publie sur son compte personnel une photo de la cuisine pédagogique avec le texte « Atelier avec les familles du quartier difficile des Tilleuls ». Analysez et réécrivez.

Corrigé

Problèmes : stigmatisation du quartier et des familles, risque d'identification indirecte, atteinte à l'image de la structure, absence d'accord de la structure. Correction : ne rien publier sur son compte personnel ; si la structure le souhaite, publication sur son compte officiel : « Atelier cuisine au centre social : merci aux familles pour ce parmentier de lentilles ! » avec une photo de plats, après validation.

6.9 Glossaire

Terme	Définition
Anonymisation	Traitement rendant impossible, de façon irréversible, toute réidentification
Autonomie	Principe de respect des choix éclairés des personnes
Bienfaisance	Principe d'action pour le bien des personnes
CNIL	Commission nationale de l'informatique et des libertés, autorité de contrôle
Conflit d'intérêts	Intérêt secondaire susceptible d'influencer le jugement professionnel
Consentement	Accord libre et éclairé d'une personne, révocable
Déontologie	Ensemble des devoirs d'une profession
Donnée de santé	Donnée personnelle relative à la santé ; catégorie particulière (art. 9 RGPD)
Donnée personnelle	Information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable
Droit à l'image	Droit de s'opposer à la prise et à la diffusion de son image (art. 9 Code civil)
Échelle d'intervention	Classement des interventions selon leur degré d'intrusion (Nuffield, 2007)
Éthique	Réflexion critique sur les valeurs face à une situation
Justice	Principe d'équité dans la répartition des ressources
Minimisation	Collecte des seules données nécessaires
Non-malfaisance	Principe de ne pas nuire
Nudge	Modification de l'architecture du choix sans interdiction
Pseudonymisation	Remplacement des identifiants par un code ; les données restent personnelles
RGPD	Règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données, applicable depuis le 25 mai 2018

Terme	Définition
Secret professionnel	Obligation de ne pas révéler les informations connues dans l'exercice professionnel
Stigmatisation	Attribution d'une identité dévalorisée à une personne ou un groupe
Allégation nutritionnelle	Mention affirmant qu'une denrée a des propriétés nutritionnelles bénéfiques (règlement 1924/2006)
Complément alimentaire	Denrée en doses destinée à compléter l'alimentation normale (décret 2006-352)
Conseil de la vie sociale	Instance de participation des personnes accueillies en établissement social ou médico-social
Démocratie en santé	Participation des usagers et citoyens aux politiques de santé
E-réputation	Image d'une personne ou d'une organisation sur internet
Nutrivigilance	Dispositif de l'ANSES recueillant les effets indésirables liés aux compléments et denrées enrichies
Responsabilité civile	Obligation de réparer un dommage causé à autrui
Responsabilité pénale	Obligation de répondre d'une infraction devant la justice
TIAC	Toxi-infection alimentaire collective : au moins deux cas groupés de même origine alimentaire ; déclaration obligatoire

6.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Principes éthiques	[1] Beauchamp et Childress ; [2] Childress et coll. ; [3] Nuffield Council
Nudge, paternalisme	[4] Thaler et Sunstein
Profession, déontologie	[5] CSP L. 4371-1 ; [6] AFDN code de déontologie
Secret, droits	[7] CSP L. 1110-4 ; [8] Code pénal 226-13 ; [9] loi du 4 mars 2002
Données	[10] RGPD ; [11] CNIL
Image	[12] Code civil art. 9
Conflits d'intérêts	[13] OMS 1981 ; [14] loi du 29 décembre 2011 ; [15] loi du 9 juin 2023
Stigmatisation	[16] Puhl et Heuer
Justice	[17] Rawls ; [18] Sen

6.12 Bibliographie numérotée

1. Beauchamp T. L., Childress J. F. *Principles of Biomedical Ethics*. Oxford University Press, 1979 (8e éd. 2019) ; trad. fr. *Les principes de l'éthique biomédicale*, Les Belles Lettres, 2008.
2. Childress J. F., Faden R. R., Gaare R. D. et coll. « Public health ethics: mapping the terrain ». *Journal of Law, Medicine & Ethics*, 2002, 30 (2), p. 170-178.
3. Nuffield Council on Bioethics. *Public health: ethical issues*. Londres, 2007.
4. Thaler R. H., Sunstein C. R. *Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness*. Yale University Press, 2008.
5. Code de la santé publique, articles L. 4371-1 à L. 4372-2 (profession de diététicien), *legifrance.gouv.fr*.

6. Association française des diététiciens nutritionnistes (AFDN). *Charte de déontologie du diététicien-nutritionniste*, 1er janvier 2018, *afdn.org* (consulté le 26 octobre 2026).

7. Code de la santé publique, article L. 1110-4.

8. Code pénal, articles 226-1, 226-13 et 226-14.

9. Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

10. Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD).

11. CNIL. Guides pratiques (« Le RGPD pour les associations », « Les durées de conservation »), *cnil.fr*.

12. Code civil, article 9.

13. OMS. *Code international de commercialisation des substituts du lait maternel*. Genève, 1981.

14. Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé ; base *transparence.sante.gouv.fr*.

15. Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

16. Puhl R. M., Heuer C. A. « Obesity stigma: important considerations for public health ». *American Journal of Public Health*, 2010, 100 (6), p. 1019-1028.

17. Rawls J. *Théorie de la justice*. Paris, Seuil, 1987 (éd. originale 1971).

18. Sen A. *L'idée de justice*. Paris, Flammarion, 2010.

19. Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine (loi Jardé).

20. Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ; arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie.

21. Code de l'action sociale et des familles, article L. 266-1 (lutte contre la précarité alimentaire), issu de la loi EGalim du 30 octobre 2018.

22. Code civil, articles 1240 et 1241.

23. Règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.

24. Décret n° 2007-263 du 27 février 2007 relatif aux messages sanitaires accompagnant les publicités alimentaires.

25. Décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ; ANSES, dispositif de nutrivigilance.

26. CNIL. Méthodologies de référence MR-001 à MR-004, *cnil.fr*.

27. Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle.

28. Habermas J. *De l'éthique de la discussion*. Paris, Cerf, 1992.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 6.2.2)

29. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE

CHAPITRE

06

Éthique et déontologie en santé publique

Valeurs | Principes | Secret | Données | Image

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

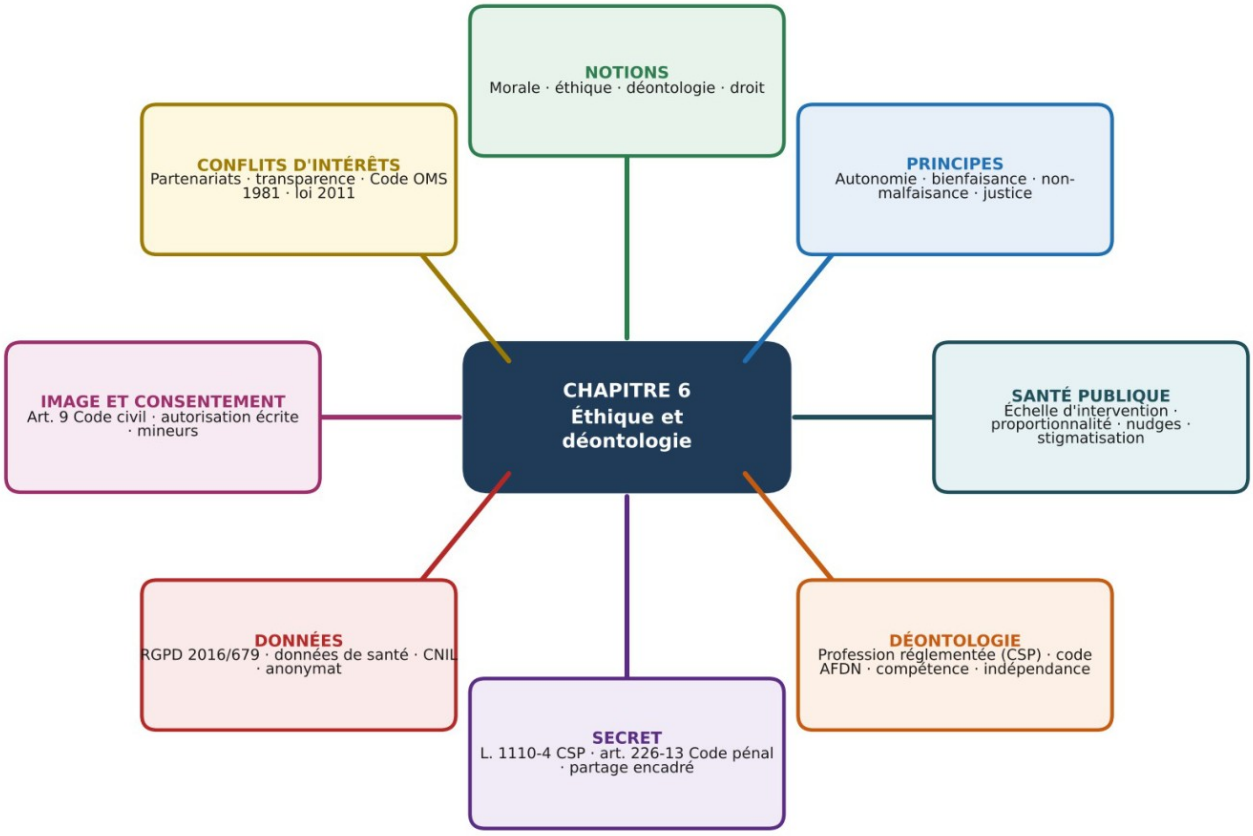
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 6 101
1. Les définitions à savoir 101
2. Les principes 101
3. Les textes et chiffres-clés 102
4. Les réflexes en action collective 102
5. Les pièges 102
6. Auto-test 102
7. Flashcards 102
Compléments du chapitre enrichi 103

Fiches-outils du chapitre 6 103
O6.1 – Autorisation de droit à l'image 103
O6.2 – Check-list RGPD d'un questionnaire ou d'un fichier 104
O6.3 – Analyse d'un partenariat 104
O6.4 – Grille d'analyse d'un dilemme éthique 105
O6.5 – Check-list « message non stigmatisant » 105

Fiche de révision du chapitre 6

Éthique et déontologie en santé publique



Carte mentale du chapitre 6

1. Les définitions à savoir

Notion	Définition
Morale	Valeurs qui distinguent le bien du mal
Éthique	Réflexion critique sur les valeurs face à une situation
Déontologie	Devoirs d'une profession (code AFDN pour les diététiciens)
Droit	Règles obligatoires et sanctionnées
Nudge	Orienter sans interdire (Thaler et Sunstein, 2008)
Conflit d'intérêts	Intérêt secondaire pouvant influencer le jugement
Pseudonymisation / anonymisation	Données encore personnelles / réidentification impossible

2. Les principes

- **Beauchamp et Childress (1979)** : autonomie · bienfaisance · non-malfaisance · justice.
- **Santé publique (Childress, 2002)** : efficacité · proportionnalité · nécessité · moindre atteinte · justification publique.

- **Échelle d'intervention (Nuffield, 2007)** : rien → informer → faciliter → défaut → inciter → désinciter → restreindre → éliminer.

3. Les textes et chiffres-clés

Texte	À retenir
L. 4371-1 CSP	Définition du diététicien, dont la prévention en santé publique
L. 1110-4 CSP	Vie privée et secret ; partage strictement nécessaire
Art. 226-13 Code pénal	Violation du secret : 1 an, 15 000 €
RGPD 2016/679	Applicable le 25 mai 2018 ; 6 principes ; données de santé (art. 9) ; jusqu'à 20 M€ ou 4 % du CA (le plus élevé)
Art. 9 Code civil	Vie privée, droit à l'image
Code OMS 1981	Pas de promotion des substituts du lait maternel
Loi du 29/12/2011	Transparence des liens d'intérêts
Loi du 9/06/2023	Influence commerciale sur les réseaux

4. Les réflexes en action collective

- Cadre de confidentialité énoncé à chaque séance ; données **agrégées** seulement.
- Questionnaire **anonyme**, minimisé, mention d'information, date de suppression.
- Autorisation d'image **écrite, par support** ; mineur : deux parents.
- Partenaire : pas de logo ni de produit promu, convention, transparence.
- Pas de pesée en public, pas de vocabulaire moral, images respectueuses.

5. Les pièges

Attention

- Croire qu'une pseudonymisation rend les données anonymes.
- Penser que la photo prise dans un lieu public dispense d'autorisation pour la diffuser.
- Accepter des échantillons de lait infantile.
- Transmettre des informations nominatives à un partenaire non soignant.
- Confondre éthique et application mécanique de règles.

6. Auto-test

1. Les 4 principes ? 2. Sanction du 226-13 ? 3. Date d'application du RGPD ? 4. Plafond pour un CA de 300 M€ ? 5. Article du Code civil sur la vie privée ? 6. Échelon de l'eau en carafe ? 7. Article du CSP définissant le diététicien ? 8. Que dit le Code OMS de 1981 ? 9. Les 5 étapes d'analyse d'un dilemme ? 10. Deux conditions éthiques d'un nudge ? *Réponses : 1. Autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice – 2. 1 an, 15 000 € – 3. 25 mai 2018 – 4. 4 % = 12 M€ < 20 M€ → 20 M€ – 5. Article 9 – 6. Orienter par défaut (4) – 7. L. 4371-1 – 8. Pas de promotion des substituts du lait maternel – 9. Faits, règles, valeurs, options, décision – 10. Transparence, réversibilité.*

7. Flashcards

Recto : Proportionnalité ?	Verso : Bénéfices > atteintes aux libertés et effets négatifs
Recto : Minimisation ?	Verso : Seulement les données nécessaires à la finalité

Recto : Proportionnalité ?	Verso : Bénéfices > atteintes aux libertés et effets négatifs
Recto : Enfant en danger ?	Verso : Référent de la structure, information préoccupante (CRIP), 119 ; 17 si urgence
Recto : Régressivité d'une taxe ?	Verso : Pèse plus, en proportion, sur les ménages modestes
Recto : Capabilités ?	Verso : Liberté réelle de convertir les ressources en santé (Sen)
Recto : Recherche impliquant la personne humaine ?	Verso : Loi Jardé 2012 ; avis d'un CPP si recherche

Compléments du chapitre enrichi

Notion	À retenir
Droits	DUDH art. 25 ; loi du 2 janvier 2002 (CVS, charte 2003) ; loi du 4 mars 2002 ; L. 266-1 CASF (précarité alimentaire, dignité, capacité à agir)
Responsabilité	Civile (faute, dommage, lien ; assurance) ; pénale ; disciplinaire ; TIAC à déclaration obligatoire ; stagiaire sous responsabilité du tuteur
Allégations	Source de fibres ≥ 3 g/100 g ; riche ≥ 6 g/100 g (ou 3 g/100 kcal) ; source de protéines ≥ 12 % de l'énergie ; allégé ≥ − 30 % ; DGCCRF
Publicité, compléments	Messages sanitaires (décret 2007) ; compléments (décret 2006-352) ; nutrivigilance ANSES
Enquêtes	Évaluation anonyme hors loi Jardé ; RIPH → CPP ; MR-004
Numérique	Identité numérique, e-réputation ; IA : confidentialité, vérification, responsabilité, intégrité

Fiches-outils du chapitre 6

Outil	Intitulé	Utilité
O6.1	Autorisation de droit à l'image	Avant toute photo ou vidéo
O6.2	Check-list RGPD d'un questionnaire ou d'un fichier	Avant collecte de données
O6.3	Analyse d'un partenariat (conflit d'intérêts)	Avant d'accepter un soutien
O6.4	Grille d'analyse d'un dilemme éthique	Situation difficile en stage
O6.5	Check-list « message non stigmatisant »	Avant diffusion d'un support

O6.1 – Autorisation de droit à l'image

Je soussigné(e) : ..... Représentant(s) légal(aux) de l'enfant (pour un mineur, signature des deux titulaires de l'autorité parentale) : .....

Autorise [structure] et [nom de l'étudiant(e)], stagiaire, à photographier ou filmer moi-même mon enfant lors

[ ]

[ ]

de [action, date, lieu], et à utiliser ces images, sans contrepartie financière et sans usage commercial, sur les supports cochés :

Support	Oui	Non
Dossier de formation et épreuve E5 (usage non public)	[ ]	[ ]
Exposition, affiche dans la structure	[ ]	[ ]
Journal ou site internet de la structure	[ ]	[ ]
Réseaux sociaux de la structure	[ ]	[ ]

Durée : 2 ans à compter de la signature. Je peux retirer cette autorisation à tout moment, pour l'avenir, par simple demande à [contact].

Date et signature(s) :

O6.2 – Check-list RGPD d'un questionnaire ou d'un fichier

Question	Fait	Mesure prise
Finalité écrite (une seule)	[ ]	
Base légale identifiée (consentement, mission d'intérêt public…)	[ ]	
Données strictement nécessaires (pas de nom, pas de poids si inutile)	[ ]	
Données de santé : justifiées ou supprimées	[ ]	
Mention d'information rédigée (qui, pourquoi, durée, droits, contact)	[ ]	
Caractère facultatif indiqué	[ ]	
Date de suppression fixée	[ ]	
Stockage sécurisé (poste de la structure, mot de passe)	[ ]	
Destruction des supports papier après saisie	[ ]	
Résultats diffusés uniquement de façon agrégée	[ ]	
Traitement inscrit au registre de la structure	[ ]	

O6.3 – Analyse d'un partenariat

Question	Réponse
Qui est le partenaire ? Quelle activité ?	
Que propose-t-il (argent, produits, locaux, supports) ?	
Quelle contrepartie demande-t-il (logo, produits, contact	
des participants) ?	
Ses produits ou intérêts sont-ils compatibles avec	
l'objectif de santé ?	
Le contenu de l'action reste-t-il décidé par l'équipe ?	
Le public est-il vulnérable (enfants, personnes	
précaires) ?	
Une convention écrite est-elle prévue ?	
Comment le soutien sera-t-il mentionné ?	
Alternatives de financement	
Décision et validation (tutrice, direction)	

O6.4 – Grille d'analyse d'un dilemme éthique

Étape	Analyse
1. Faits (qui, quoi, quand, où)	
2. Règles (droit, déontologie,	
structure)	
3. Valeurs en tension	
4. Options (au moins 3) et	
conséquences	
5. Décision, justification,	
personnes consultées,	
traçabilité	

O6.5 – Check-list « message non stigmatisant »

Critère	Oui	Non
Le message parle de comportements et d'environnements, pas de corps	[ ]	[ ]
Il valorise le plaisir, la santé, le partage	[ ]	[ ]
Aucun vocabulaire moral (bon/mauvais, interdit, tricher)	[ ]	[ ]
Images de personnes de toutes corpulences, actives, avec un visage	[ ]	[ ]
Pas de « avant/après » ni de chiffre de poids	[ ]	[ ]
Les déterminants collectifs sont évoqués	[ ]	[ ]
Des solutions accessibles (prix, temps) sont proposées	[ ]	[ ]
Le support a été relu par des personnes du public	[ ]	[ ]

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES

CHAPITRE

06

Éthique et déontologie en santé publique

Valeurs · Principes · Secret · Données · Image

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 6 109
Mode d'emploi du cahier 109
Partie 1 – Les fondements : éthique, principes et stigmatisation 111
Exercice 6.1 – Morale, éthique, déontologie ou droit ? (10 points) 112
Exercice 6.2 – Les quatre principes dans l'atelier (10 points) 114
Exercice 6.3 – Justifier une mesure qui restreint le choix (12 points) 115
Exercice 6.4 – Placer des mesures sur l'échelle d'intervention (10 points) 117
Exercice 6.5 – Un nudge au restaurant d'entreprise (12 points) 118
Exercice 6.6 – Une affiche qui stigmatise (16 points) 120
Corrigés de la partie 1 122
Partie 2 – Le cadre professionnel et le secret 124
Exercice 6.7 – Les cercles du secret (10 points) 125
Exercice 6.8 – Une profession réglementée (10 points) 127
Exercice 6.9 – Le secret dans le groupe (12 points) 129
Exercice 6.10 – Partager dans l'équipe, pas au-delà (12 points) 131
Exercice 6.11 – Un enfant semble en danger (12 points) 133
Exercice 6.12 – Neutralité, laïcité et menus (16 points) 135
Corrigés de la partie 2 137
Partie 3 – Protéger les données personnelles (RGPD) 140
Exercice 6.13 – De la donnée identifiante à la donnée agrégée (10 points) 141
Exercice 6.14 – Répondre aux droits des personnes (10 points) 143
Exercice 6.15 – Le cycle de vie des données d'une enquête (12 points) 145
Exercice 6.16 – Des résultats qui identifient (12 points) 147
Exercice 6.17 – Dates de conservation et registre (12 points) 149
Exercice 6.18 – Une application de suivi alimentaire dans un programme de prévention (16 points) 151
Corrigés de la partie 3 153
Partie 4 – Le consentement et le droit à l'image 155
Exercice 6.19 – Les qualités du consentement (10 points) 156
Exercice 6.20 – Peut-on prendre cette photo ? (10 points) 158
Exercice 6.21 – Corriger une autorisation de droit à l'image (12 points) 160
Exercice 6.22 – Le consentement des personnes vulnérables (12 points) 162
Exercice 6.23 – Une enquête auprès de collégiens (12 points) 163
Exercice 6.24 – Une vidéo de valorisation qui respecte chacun (16 points) 164
Corrigés de la partie 4 166
Partie 5 – Conflits d'intérêts et partenariats 169
Exercice 6.25 – Gérer un lien d'intérêts (10 points) 170
Exercice 6.26 – Le feu tricolore des partenariats (10 points) 171
Exercice 6.27 – La part d'un financement privé (12 points) 173
Exercice 6.28 – Le Code international des substituts du lait maternel (12 points) 175
Exercice 6.29 – Lire une déclaration d'intérêts (12 points) 176
Exercice 6.30 – Le forum santé des seniors (16 points) 177
Corrigés de la partie 5 179
Partie 6 – Allégations, publicité et compléments alimentaires 182
Exercice 6.31 – Les types d'allégations (10 points) 183
Exercice 6.32 – Trier dix mentions d'emballage (10 points) 185
Exercice 6.33 – Vérifier une allégation par le calcul (14 points) 187
Exercice 6.34 – Publicité alimentaire et messages sanitaires (12 points) 189
Exercice 6.35 – Le complément « minceur détox » (12 points) 191

Exercice 6.36 – Une publication d'influenceur (14 points) 193
Corrigés de la partie 6 195
Partie 7 – Enquêtes, recherche et identité numérique 198
Exercice 6.37 – Enquête ou recherche ? (10 points) 199
Exercice 6.38 – Rédiger une note d'information (10 points) 201
Exercice 6.39 – Taux de participation et biais (12 points) 202
Exercice 6.40 – Mon identité numérique (10 points) 204
Exercice 6.41 – L'intelligence artificielle au service du diététicien (12 points) 206
Exercice 6.42 – Répondre à un avis négatif en ligne (14 points) 207
Corrigés de la partie 7 209
Partie 8 – Synthèse : droits, responsabilité, dignité et cas complet 211
Exercice 6.43 – Le judoka qui doit « faire le poids » (10 points) 212
Exercice 6.44 – Des droits très concrets au foyer (10 points) 213
Exercice 6.45 – Responsabilité et toxi-infection après un buffet (12 points) 214
Exercice 6.46 – La dignité à l'épicerie solidaire (12 points) 216
Exercice 6.47 – Rédiger la partie « éthique » d'une fiche projet (12 points) 218
Exercice 6.48 – Cas complet : les repas partagés du foyer de jeunes travailleurs (40 points) 219
Corrigés de la partie 8 222
Bilan : grille d'auto-évaluation 226

Cahier d'exercices – Chapitre 6

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 6 : morale, éthique, déontologie et droit ; principes de Beauchamp et Childress et principes propres à la santé publique ; échelle d'intervention et nudges ; stigmatisation ; cadre professionnel du diététicien ; secret professionnel et secret partagé ; protection des données (RGPD) ; consentement et droit à l'image ; conflits d'intérêts et partenariats ; allégations, publicité et compléments alimentaires ; enquêtes et recherche ; identité numérique et intelligence artificielle ; droits des usagers, responsabilité et démarche de réflexion éthique (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition », C3.3 « Participer à des activités de recherche appliquée en nutrition humaine », C3.5 « Communiquer et interagir dans un contexte d'intervention en santé » et C3.6 « Maintenir son environnement numérique de travail sécurisé » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les cercles du secret, de la donnée identifiante à la donnée agrégée, les droits des personnes, le cycle de vie des données, les qualités du consentement, l'arbre de décision du droit à l'image, la gestion d'un lien d'intérêts, le feu tricolore des partenariats, les types d'allégations, le cadre d'une enquête selon sa finalité, l'identité numérique.
- Calculer et interpréter : taux de participation et d'autorisation, part d'un financement, dates de conservation et de suppression, plafonds de sanction, seuils d'allégations, coût par portion (Ciqual 2025), taille de petits groupes et risque de réidentification.
- Rédiger des réponses courtoises et argumentées à des demandes qui posent problème, sans moraliser.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits d'entretiens), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, marques, prix et chiffres des enquêtes locales sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025). Les textes officiels, les auteurs et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la règle et les personnes.

Méthode – Traiter une question d'éthique à l'examen

Pour chaque situation, suivez quatre temps. D'abord, décrivez les faits sans jugement et nommez les personnes concernées. Ensuite, citez la règle en jeu avec sa source (Code pénal, Code civil, Code de la santé publique, RGPD, règlement sur les allégations) et le principe éthique (autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice, non-stigmatisation). Puis comparez au moins deux options et leurs conséquences. Enfin,

écrivez la réponse que vous donneriez réellement à la personne, en une ou deux phrases polies, avec une solution de remplacement. Une copie qui se contente de « c'est interdit » ou qui fait la morale perd des points.

Partie 1 – Les fondements : éthique, principes et stigmatisation

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer morale, éthique, déontologie et droit.
- Appliquer les quatre principes de Beauchamp et Childress (1979) à des situations de nutrition.
- Utiliser les conditions de justification d'une action de santé publique (Childress et coll., 2002).
- Classer des mesures sur l'échelle d'intervention du Nuffield Council on Bioethics (2007) et juger un nudge.
- Repérer et corriger un message stigmatisant.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Morale : valeurs et normes du bien et du mal ; éthique : réflexion critique sur ces valeurs face à une situation concrète ; déontologie : devoirs d'une profession (charte de déontologie du diététicien-nutritionniste de l'AFDN, 1er janvier 2018) ; droit : règles obligatoires et sanctionnées par l'État.
- Quatre principes (Beauchamp et Childress, 1979) : autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice ; ils ne se hiérarchisent pas a priori.
- Conditions d'une action qui restreint les libertés (Childress et coll., 2002) : efficacité, proportionnalité, nécessité, moindre atteinte, justification publique.
- Échelle d'intervention (Nuffield Council on Bioethics, 2007) : ne rien faire ou surveiller, informer, faciliter, orienter par défaut, inciter, désinciter, restreindre, éliminer le choix.
- Nudge (Thaler et Sunstein, 2008) : modifier l'architecture du choix sans interdire ; conditions éthiques : transparence, réversibilité, finalité de santé, équité.
- La stigmatisation du poids est contraire au principe de non-malfaisance : parler de comportements et d'environnements, pas de corps.

Exercice 6.1 – Morale, éthique, déontologie ou droit ? (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une séance d'accueil pour deux nouvelles stagiaires du service de santé publique d'une ville. Vous leur proposez de classer des phrases entendues dans le service.

Document 1 – Dix phrases entendues

a) « La révélation d'une information à caractère secret est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

b) « Mentir, ce n'est pas bien. »

c) « Faut-il prévenir la famille d'un participant qui semble isolé, alors qu'il ne l'a pas demandé ? Discutons-en en équipe. »

d) « Le diététicien actualise ses connaissances tout au long de sa carrière. »

e) « On ne doit pas gaspiller la nourriture. »

f) « Toute personne a droit au respect de sa vie privée. »

g) « Le diététicien refuse toute influence commerciale sur ses messages. »

h) « Peut-on proposer une récompense aux enfants qui goûtent un légume, sans les manipuler ? »

i) « Une photo d'un participant ne peut pas être diffusée sans son autorisation. »

j) « Le professionnel oriente vers le médecin quand la situation dépasse son champ de compétence. »

À vous de jouer – Questions

1. Définissez en une phrase la morale, l'éthique, la déontologie et le droit. (4 pts)
2. Classez les dix phrases du document 1 dans ces quatre catégories. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi une conduite peut être légale mais discutable sur le plan éthique, avec un exemple en nutrition. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.2 – Les quatre principes dans l'atelier (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un cycle d'ateliers « Cuisine du quotidien » dans une maison de quartier (structure fictive). Votre tutrice vous demande d'analyser vos pratiques avec les principes de Beauchamp et Childress.

Document 1 – Huit pratiques observées

a) Chaque participant choisit de goûter ou non, sans avoir à se justifier.

b) Les recettes choisies respectent les repères de Santé publique France (2019) et un budget de 2 € par portion.

c) Une animatrice dit à une participante : « Avec votre poids, évitez le fromage. »

d) Les ateliers ont lieu le mercredi à 10 h ; les parents qui travaillent ne peuvent pas venir.

e) Les allergies sont demandées à l'inscription et vérifiées sur chaque étiquette.

f) Une affiche indique « Atelier pour les familles en difficulté ».

g) Une participante qui ne lit pas le français reçoit la recette en photos.

h) La pesée des participants est proposée en début de séance « pour suivre les progrès ».

À vous de jouer – Questions

1. Définissez les quatre principes de Beauchamp et Childress. (4 pts)
2. Pour chaque pratique du document 1, indiquez le principe concerné et s'il est respecté ou menacé. (4 pts)
3. Proposez une correction pour deux pratiques qui menacent un principe. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.3 – Justifier une mesure qui restreint le choix (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre hospitalier de Lormel (fictif) a retiré les sodas de ses distributeurs automatiques et les a remplacés par de l'eau gratuite aux fontaines, de l'eau en bouteille et des fruits. Le comité de prévention vous demande si cette mesure est éthiquement justifiable.

Document 1 – Données du service logistique (données fictives)

- Avant la mesure : 1 240 canettes de soda de 33 cL vendues par mois dans les distributeurs, à 10,6 g de sucres pour 100 mL.
- Après la mesure : 1 610 bouteilles d'eau et 410 fruits vendus par mois ; fréquentation des fontaines non mesurée.
- 23 réclamations écrites sur 900 salariés pendant le premier mois ; une pétition de 41 signatures demande « le retour du choix ».
- La cafétéria voisine, ouverte de 7 h à 15 h, vend toujours des sodas ; les distributeurs sont les seuls points de vente la nuit.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la quantité de sucres vendue chaque mois par les distributeurs avant la mesure, en kilogrammes et en morceaux de 5 g. (2 pts)
2. Calculez le taux de réclamation et commentez. (1 pt)
3. Appliquez à la mesure les cinq conditions de Childress et coll. (2002). (5 pts)
4. Situez la mesure sur l'échelle d'intervention et dites quelle mesure moins contraignante aurait pu être essayée. (2 pts)
5. Proposez un complément qui rendrait la mesure plus juste pour les équipes de nuit. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.4 – Placer des mesures sur l'échelle d'intervention (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté de communes (fictive) prépare son projet alimentaire territorial. Les élus vous demandent de classer les mesures envisagées pour la restauration scolaire et les lieux publics.

Document 1 – Neuf mesures envisagées

a) Enquête annuelle sur la consommation de fruits des élèves.

b) Affiches sur les légumes de saison dans les écoles.

c) Prêt gratuit de matériel de cuisine aux associations.

d) Plat végétarien servi par défaut au self du collège, plat avec viande sur demande.

e) Réduction de 20 % sur les fruits à la cafétéria du centre aquatique.

f) Supplément de 0,50 € sur les desserts les plus sucrés de la cafétéria.

g) Salières retirées des tables, disponibles sur demande.

h) Boissons sucrées limitées aux bouteilles de 25 cL dans les distributeurs des gymnases.

i) Suppression de toutes les boissons sucrées dans les équipements sportifs.

À vous de jouer – Questions

1. Citez dans l'ordre les huit échelons de l'échelle du Nuffield Council on Bioethics (2007). (4 pts)

2. Placez chaque mesure du document 1 sur un échelon. (4,5 pts)

3. Expliquez pourquoi plus on monte sur l'échelle, plus la justification exigée est forte. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.5 – Un nudge au restaurant d'entreprise (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le restaurant d'une entreprise de 900 salariés (fictive) sert 620 repas par jour. Le prestataire a modifié l'organisation du self pendant un mois. Le comité social et économique vous demande si ces changements sont éthiques.

Document 1 – Les changements et leurs effets (données fictives)

- Le plat végétarien est placé en premier sur la ligne de self, avec une photo ; le plat avec viande est placé en second.
- Les fruits sont posés à hauteur des yeux, les desserts sucrés dans une vitrine basse.
- Les assiettes de frites sont plus petites qu'avant, sans baisse de prix et sans information.
- L'eau est servie en carafe sur chaque table.
- Une affiche à l'entrée explique : « Nous mettons en avant les choix bons pour la santé et la planète. Tous les plats restent disponibles. »
- Plats végétariens choisis : 112 sur 620 avant ; 254 sur 620 après.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez un nudge et citez les quatre conditions de son usage éthique. (3 pts)

2. Calculez la part des plats végétariens avant et après, et l'évolution en points et en rapport. (3 pts)

3. Examinez chacun des quatre premiers changements avec les quatre conditions. Lequel pose problème ? Pourquoi ? (4 pts)

4. Proposez une correction du changement problématique. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.6 – Une affiche qui stigmatise (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

La mairie de Saint-Ervan (fictive) a affiché dans ses abris de bus une campagne : photo d'un ventre d'homme en surpoids, sans visage, avec le texte « Obésité : stop aux excuses ! Bougez-vous, mangez moins ! ». La responsable du service de santé vous demande de l'analyser et de proposer une autre campagne.

Document 1 – Enquête rapide auprès de 50 habitants à la sortie du marché (données fictives)

- 31 trouvent l'affiche « culpabilisante » ; 12 disent qu'elle leur « donne envie d'agir » ; 9 n'ont pas compris ce qu'elle demande.
- Paroles : « On dirait que c'est de notre faute. » ; « Je ne vais plus à la piscine depuis que je vois ce genre d'image. » ; « Moi je veux bien bouger, mais il n'y a pas de piste cyclable. »

Document 2 – Test d'une nouvelle affiche auprès de 40 habitants (données fictives)

Nouvelle affiche : photo d'une famille qui cuisine au marché ; texte « Le marché, c'est aussi des recettes : ateliers gratuits le samedi » ; logo de la mairie. Résultats : 29 ont envie de participer ; 4 la trouvent culpabilisante ; 7 sans avis.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages des documents 1 et 2 et comparez les deux affiches. (3 pts)
2. Relevez quatre éléments stigmatisants ou culpabilisants dans la première affiche et nommez le principe éthique menacé. (4 pts)
3. Expliquez, avec une parole du document 1, pourquoi la stigmatisation peut aggraver la santé. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi le message « mangez moins, bougez-vous » ignore les déterminants de santé. (2 pts)
5. Proposez trois autres actions qui agissent sur l'environnement, et trois règles de communication pour la suite de la campagne. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 6.1

1. **Morale** : ensemble des valeurs et des normes qui distinguent le bien du mal, dans une société ou pour une personne. **Éthique** : réflexion critique sur ces valeurs, face à une situation concrète, pour décider de la conduite la plus juste. **Déontologie** : ensemble des devoirs d'une profession, formalisés dans un code. **Droit** : règles obligatoires, fixées et sanctionnées par l'État.
2. Droit : a) (article 226-13 du Code pénal), f) (article 9 du Code civil), i) (droit à l'image). Morale : b), e). Éthique : c), h) (questions sur une situation, avec des valeurs en tension). Déontologie : d), g), j) (devoirs du professionnel : compétence, indépendance, orientation).
3. La loi n'interdit pas tout ce qui est discutable. Exemple : une campagne qui montre des corps en surpoids sans visage est légale, mais elle stigmatise les personnes et peut leur nuire (non-malfaisance).

Corrigé – Exercice 6.2

1. **Autonomie** : respecter la capacité de chacun à décider pour lui-même, après une information claire. **Bienfaisance** : agir pour le bien des personnes avec des actions utiles et fondées sur des preuves. **Non-malfaisance** : ne pas nuire (stigmatisation, culpabilisation, restriction, danger). **Justice** : répartir équitablement les ressources et l'accès, selon les besoins.
2. a) autonomie, respectée ; b) bienfaisance, respectée ; c) non-malfaisance menacée (remarque sur le poids, devant le groupe) et autonomie (conseil imposé) ; d) justice menacée (horaires qui excluent les parents qui travaillent) ; e) non-malfaisance, respectée (sécurité) ; f) non-malfaisance et justice menacées (étiquette stigmatisante qui peut éloigner les familles visées) ; g) justice et autonomie, respectées (accès à l'information pour tous) ; h) non-malfaisance menacée (pesée en groupe sans objectif de soin, risque de honte et de restriction).
3. Exemples : c) ne jamais commenter le poids ; parler du plaisir de cuisiner et, si la personne le demande, l'orienter en privé vers une consultation ; d) ajouter une séance le samedi matin ou en soirée ; f) « Ateliers cuisine ouverts à tous » ; h) supprimer la pesée et évaluer par des indicateurs de pratiques (recettes refaites, satisfaction).

Corrigé – Exercice 6.3

1. Sucres par canette : 10,6 × 330 / 100 = **34,98 g**. Par mois : 1 240 × 34,98 = **43 375 g**, soit environ **43,4 kg**, ou 43 375 / 5 = **8 675 morceaux** de sucre.
2. 23 / 900 × 100 = **2,6 %** des salariés ont réclamé par écrit, et 41 ont signé la pétition (4,6 %) : l'opposition est réelle mais minoritaire ; il faut l'écouter et y répondre publiquement.
3. **Efficacité** : la mesure supprime une source importante de sucres libres et les ventes d'eau et de fruits montrent un report ; mais on ignore si les salariés achètent des sodas ailleurs (cafétéria). **Proportionnalité** : l'atteinte à la liberté est faible (les sodas restent disponibles à la cafétéria et à l'extérieur) au regard du bénéfice attendu. **Nécessité** : on peut se demander si une mesure moins contraignante (prix, emplacement) aurait suffi. **Moindre atteinte** : le choix n'est supprimé que dans les distributeurs, et une alternative gratuite est offerte (fontaines). **Justification publique** : la direction doit expliquer la mesure, ses raisons et son évaluation, et répondre à la pétition.
4. La mesure se situe au niveau « éliminer le choix » dans les distributeurs, ou « restreindre » si l'on considère l'ensemble de l'hôpital, puisque la cafétéria vend encore des sodas. Mesures moins contraignantes : proposer des boissons sans sucres ajoutés en plus grand nombre, augmenter le prix des sodas (désinciter) ou les placer en bas (orienter par défaut).
5. Les équipes de nuit n'ont plus aucun choix de boisson sucrée et aucun autre point de vente : on peut proposer, la nuit, des boissons chaudes et des collations variées dans les offices, une fontaine d'eau fraîche dans chaque service et une consultation des représentants des équipes de nuit avant de généraliser.

Corrigé – Exercice 6.4

1. Ne rien faire ou surveiller ; informer ; faciliter les choix ; orienter par défaut ; inciter ; désinciter ; restreindre les choix ; éliminer le choix.

2. a) surveiller ; b) informer ; c) faciliter ; d) orienter par défaut ; e) inciter ; f) désinciter ; g) orienter par défaut (le choix reste possible sur demande) ; h) restreindre ; i) éliminer le choix (dans ces lieux).

3. Plus une mesure est haute sur l'échelle, plus elle limite la liberté des personnes. Pour être acceptable, elle doit répondre à un problème grave, avoir des preuves d'efficacité et ne pas avoir d'alternative moins contraignante, comme le demandent les conditions de proportionnalité et de nécessité.

Corrigé – Exercice 6.5

1. Un nudge modifie la manière dont les choix sont présentés pour orienter les comportements, sans interdire aucune option ni changer fortement les prix (Thaler et Sunstein, 2008). Conditions éthiques : transparence, réversibilité (tous les choix restent possibles), finalité de santé (et non commerciale), équité.

2. Avant : 112 / 620 × 100 = **18,1 %** ; après : 254 / 620 × 100 = **41,0 %**. Évolution : + **22,9 points** ; rapport 254 / 112 = **2,27** : le nombre de plats végétariens choisis a été multiplié par 2,27.

3. Plat végétarien en premier : transparent (affiche), réversible, finalité de santé et d'environnement, équitable ; acceptable. Fruits à hauteur des yeux : mêmes conclusions ; acceptable. Eau en carafe : acceptable et même favorable à l'équité (gratuite). **Portions de frites plus petites, sans information ni baisse de prix** : pas de transparence, et les salariés paient autant pour moins ; c'est le changement qui pose problème.

4. Informer clairement (« portion de frites réduite, prix réduit » ou « deuxième portion gratuite sur demande »), adapter le prix, ou proposer d'office la moitié frites et la moitié légumes au même prix, avec une affiche.

Corrigé – Exercice 6.6

1. Affiche 1 : culpabilisante 31 / 50 = **62 %** ; envie d'agir 12 / 50 = **24 %** ; incompréhension 9 / 50 = **18 %**. Affiche 2 : envie de participer 29 / 40 = **72,5 %** ; culpabilisante 4 / 40 = **10 %** ; sans avis 7 / 40 = **17,5 %**. La seconde affiche donne envie d'agir trois fois plus souvent (72,5 % contre 24 %) et culpabilise six fois moins (10 % contre 62 %).

2. Photo d'un corps sans visage, qui réduit la personne à son ventre ; « stop aux excuses », qui suggère que les personnes sont paresseuses ou de mauvaise foi ; impératifs « bougez-vous, mangez moins » ; ciblage d'un problème de santé à travers un corps, et non des comportements ou des environnements. Principe menacé : non-malfaisance, et aussi justice (on fait porter le problème aux personnes les plus touchées).

3. « Je ne vais plus à la piscine depuis que je vois ce genre d'image » : la honte pousse à éviter les lieux d'activité physique et parfois les soins ; la stigmatisation est associée à une moins bonne santé mentale et à des conduites alimentaires désordonnées.

4. Le poids dépend de nombreux déterminants : revenus, offre alimentaire, temps, sommeil, stress, aménagement de la ville (« il n'y a pas de piste cyclable »). Un message individuel ignore ces déterminants et culpabilise ceux qui ont le moins de prise sur eux.

5. Actions : pistes cyclables et parcours de marche éclairés ; ateliers cuisine gratuits au marché ; fontaines d'eau dans les parcs ; créneaux de piscine en petits groupes. Règles : montrer des personnes de toutes corpulences, actives, avec un visage ; parler de plaisir, de santé et de lien social plutôt que de poids ; tester chaque affiche auprès d'habitants avant diffusion.

Partie 2 – Le cadre professionnel et le secret

Objectifs – Objectifs de la partie

- Situer le cadre juridique et déontologique de la profession de diététicien.
- Appliquer le secret professionnel dans une action collective.
- Distinguer partage d'informations dans une équipe de soins et transmission à des partenaires.
- Connaître la conduite à tenir face à un enfant en danger.
- Appliquer la neutralité et la laïcité dans une action de santé publique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Article L. 4371-1 du Code de la santé publique : définition de la profession ; titre protégé ; usurpation de titre punie (renvoi à l'article 433-17 du Code pénal) ; charte de déontologie de l'AFDN (1er janvier 2018), sans ordre professionnel ni code publié par décret.
- Secret : article L. 1110-4 du Code de la santé publique (loi du 4 mars 2002) ; violation punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (article 226-13 du Code pénal).
- Équipe de soins : partage des seules informations strictement nécessaires, la personne étant informée ; hors équipe : accord de la personne.
- Partenaires et employeurs : uniquement des données collectives et anonymes.
- Enfant en danger : en parler sans délai au responsable ; information préoccupante à la cellule départementale (CRIP), 119 ; 17 en cas de danger immédiat.
- Neutralité : obligation des agents publics (et réserve du stagiaire en service public) ; les usagers sont libres de leurs convictions.

Exercice 6.7 – Les cercles du secret (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une fiche pour les bénévoles d'une association qui organise des ateliers cuisine avec des personnes atteintes de diabète. Vous leur expliquez à qui l'on peut parler de ce qu'un participant a confié.

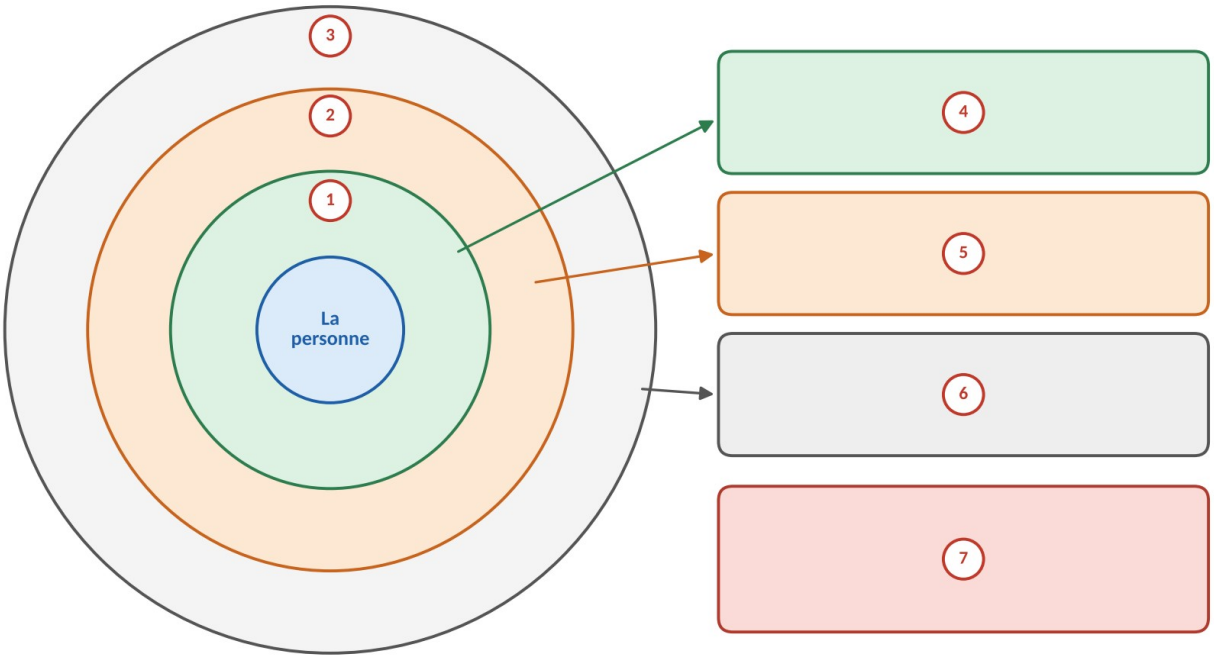


Figure 6.1 – Document 1 – Les cercles du secret en action collective (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (5 pts)
2. Citez l'article du Code de la santé publique et celui du Code pénal qui fondent le secret, ainsi que la sanction encourue. (3 pts)
3. Un bénévole n'est pas un professionnel de santé. Expliquez pourquoi il doit tout de même respecter la confidentialité. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.8 – Une profession réglementée (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mairie (fictive) souhaite recruter un intervenant pour des ateliers de nutrition. Elle reçoit trois candidatures et vous demande votre avis.

Document 1 – Trois candidatures

- Candidat A : « Coach en nutrition certifié après une formation en ligne de 40 heures ; je propose des programmes minceur et des compléments de ma marque. »
- Candidate B : « Titulaire du BTS Diététique et nutrition (2023), enregistrée auprès de l'agence régionale de santé ; deux ans d'expérience en restauration collective. »
- Candidat C : « Nutritionniste, naturopathe ; je soigne l'intestin par l'alimentation et je propose des tests d'intolérances alimentaires. »

Document 2 – Six affirmations à vérifier

a) Le titre de diététicien peut être utilisé par toute personne qui a suivi une formation en nutrition.

b) Le titre de « nutritionniste » seul n'est pas protégé.

c) Il existe un ordre national des diététiciens.

d) Le diététicien doit faire enregistrer son diplôme avant d'exercer.

e) La charte de déontologie des diététiciens est publiée par l'AFDN.

f) Un diététicien peut participer à des activités de prévention en santé publique.

À vous de jouer – Questions

1. Dites si chaque affirmation du document 2 est vraie ou fausse et corrigez les fausses. (3 pts)

2. Analysez les trois candidatures (titre, compétences, risques pour le public, conflits d'intérêts). (5 pts)

3. Rédigez l'avis que vous transmettez à la mairie, en trois phrases. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.9 – Le secret dans le groupe (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un cycle de six ateliers « Manger avec un petit budget » dans un centre social (fictif). Plusieurs situations se présentent au fil des séances.

Document 1 – Six situations

a) Au premier atelier, une participante raconte qu'elle est suivie pour un cancer.

b) La directrice du centre social vous demande « qui a des problèmes de diabète dans le groupe » pour adapter le goûter de la fête de quartier.

c) Un participant confie en aparté qu'il vient de perdre son emploi et ne peut plus payer la cantine de ses enfants.

d) Le financeur demande « la liste des participants et leurs résultats ».

e) Une participante vous demande, devant le groupe, pourquoi Mme L. ne vient plus.

f) Vous voulez écrire un article sur l'atelier dans la lettre d'information du centre social.

À vous de jouer – Questions

1. **1.** Rédigez la règle de confidentialité que vous énoncez au premier atelier. (2 pts)
2. **2.** Pour chaque situation, indiquez la conduite à tenir et justifiez-la. (9 pts)
3. **3.** Indiquez où et comment vous conservez vos notes d'animation. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.10 – Partager dans l'équipe, pas au-delà (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans une maison de santé pluriprofessionnelle (fictive) qui organise un programme d'éducation thérapeutique pour des patients diabétiques. Mme T., 54 ans, participe aux ateliers collectifs.

Document 1 – Ce que vous savez de Mme T.

- Elle a un diabète de type 2 ; son médecin traitant a inscrit au dossier une HbA1c de 8,4 %.
- Pendant l'atelier, elle a confié qu'elle saute souvent le dîner « parce que le frigo est vide à la fin du mois ».
- Elle travaille comme aide-ménagère pour l'entreprise de nettoyage qui finance en partie le programme ; son responsable vous appelle pour savoir « si elle suit bien ».
- Sa fille vous demande, à la sortie, « ce que le médecin a dit ».
- L'infirmière du programme prépare l'entretien individuel de Mme T. la semaine suivante.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez ce qu'est une équipe de soins et les conditions du partage d'informations (article L. 1110-4 du Code de la santé publique). (3 pts)
2. Pour chacune des trois personnes (responsable de l'entreprise, fille, infirmière), dites quelles informations vous pouvez partager et rédigez votre réponse. (6 pts)
3. Comment aborder avec Mme T. la question du frigo vide, et vers qui l'orienter ? (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.11 – Un enfant semble en danger (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un atelier « petit-déjeuner » dans un accueil de loisirs (fictif) pour des enfants de 6 à 10 ans. Noah, 8 ans, dévore le pain et dit : « À la maison, il n'y a jamais rien le matin, et le soir non plus. » Vous remarquez qu'il porte les mêmes vêtements depuis trois séances et qu'il a un bleu sur le bras.

Document 1 – Repères (données réelles)

- Le secret professionnel ne s'oppose pas à la protection de l'enfance : le professionnel qui a connaissance d'une situation de danger ou de risque de danger pour un mineur doit la signaler par les voies prévues.
- Information préoccupante : transmise à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) du conseil départemental, qui l'évalue.
- Le 119 (Allô enfance en danger) est gratuit et joignable 24 heures sur 24.
- En cas de danger grave et immédiat : appel au 17 ou signalement au procureur de la République.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi vous ne devez ni ignorer la situation, ni mener vous-même une enquête auprès de la famille. (3 pts)
2. Décrivez, dans l'ordre, ce que vous faites pendant l'atelier, juste après, et dans les jours suivants. (5 pts)
3. Rédigez la note factuelle que vous remettez à la directrice de l'accueil de loisirs (faits observés, paroles exactes, date), sans interprétation. (3 pts)
4. Que répondez-vous à Noah s'il vous demande de « ne rien dire » ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.12 – Neutralité, laïcité et menus (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes stagiaire au service de restauration scolaire d'une commune (fictive) qui sert 380 repas par jour dans ses écoles élémentaires. La commune propose un plat de remplacement quand le plat contient du porc, et un menu végétarien une fois par semaine.

Document 1 – Données et situations (données fictives)

- À l'inscription, 84 familles ont demandé « pas de porc » et 31 « pas de viande » ; les autres n'ont rien demandé.
- Une élue propose de supprimer le plat de remplacement « au nom de la laïcité ».
- Un parent demande que la cantine serve de la viande certifiée selon un rite religieux.
- Une animatrice périscolaire dit à un enfant devant ses camarades : « Ta religion t'interdit le porc, donc tu prends les lentilles. »
- Une collègue stagiaire souhaite porter un signe religieux visible pendant son stage au service.

Document 2 – Repères (données réelles)

- La loi du 9 décembre 1905 garantit la liberté de conscience et sépare les Églises et l'État ; les agents publics sont soumis à une obligation de neutralité.
- Aucun texte n'oblige une commune à proposer des menus de substitution, et aucun texte ne les interdit : c'est un choix de la collectivité, qui doit tenir compte de l'intérêt des enfants.
- La loi EGalim (30 octobre 2018) impose au moins un menu végétarien par semaine en restauration scolaire.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part des familles qui demandent « pas de porc », « pas de viande » et l'ensemble des demandes particulières. (2 pts)
2. Un jour où le plat contient du porc, combien de plats de remplacement faut-il prévoir ? Proposez une organisation qui simplifie le service sans stigmatiser. (3 pts)
3. Expliquez la différence entre neutralité du service public et liberté des usagers, avec deux situations du document 1. (4 pts)
4. Analysez la phrase de l'animatrice et proposez une autre formulation. (3 pts)
5. Rédigez un argumentaire de cinq lignes pour l'élue, centré sur la santé et l'intérêt des enfants. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 6.7

1. Légendes : 1 Équipe de soins ; 2 Autres professionnels ; 3 Partenaires, famille, employeur ; 4 partage limité au strict nécessaire, la personne étant informée (L. 1110-4 CSP) ; 5 seulement avec l'accord de la personne ; 6 aucune information individuelle : données collectives et anonymes ; 7 exception : enfant en danger → responsable, CRIP ou 119 (17 si danger immédiat).
2. Article L. 1110-4 du Code de la santé publique (droit au respect de la vie privée et au secret des informations) ; article 226-13 du Code pénal : un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
3. Le bénévole reçoit des confidences dans le cadre de l'action ; les divulguer porterait atteinte à la vie privée des participants (article 9 du Code civil), romprait leur confiance et pourrait les exposer à des discriminations. La règle de confidentialité du groupe s'applique à tous, et la structure est responsable de la faire respecter.

Corrigé – Exercice 6.8

1. a) Faux : le titre est réservé aux titulaires des diplômes reconnus (BTS Diététique et nutrition, BUT génie biologique parcours diététique et nutrition, diplômes européens autorisés). b) Vrai. c) Faux : il n'existe pas d'ordre des diététiciens. d) Vrai : enregistrement obligatoire auprès de l'ARS. e) Vrai : c'est la « Charte de déontologie du diététicien-nutritionniste » du 1er janvier 2018 (ce n'est pas un code publié par décret). f) Vrai : l'article L. 4371-1 mentionne les activités de prévention en santé publique relevant de la nutrition.
2. A : titre non protégé, formation courte non reconnue, programmes minceur (risque de restriction) et vente de ses produits (conflit d'intérêts direct) ; à écarter. B : diplômée et enregistrée, expérience utile ; candidature conforme. C : « nutritionniste » et « naturopathe » ne sont pas des titres protégés ; « soigner » par l'alimentation et proposer des tests d'intolérances sans validation scientifique exposent le public à des erreurs et à des dépenses inutiles ; à écarter.
3. Exemple : « Seule la candidate B porte le titre protégé de diététicienne et présente les garanties de compétence attendues. Les candidats A et C proposent des pratiques non validées et, pour A, la vente de ses propres produits, ce qui crée un conflit d'intérêts. Je vous recommande la candidate B et la signature d'une convention précisant le contenu des ateliers. »

Corrigé – Exercice 6.9

1. Exemple : « Dans ce groupe, chacun parle de ce qu'il veut. Ce qui est dit ici reste ici. On ne juge pas ce que mangent les autres. Personne n'est obligé de répondre ou de goûter. »
2. a) Remercier sans insister ; l'information reste dans le groupe ; adapter discrètement si elle le demande ; ne rien noter de nominatif. b) Ne pas donner de noms : proposer un goûter adapté à tous (fruits, pain, eau), qui convient aussi aux personnes diabétiques. c) Écouter en privé, ne rien dire au groupe, proposer avec son accord une orientation (assistante sociale, CCAS, tarif social de la cantine). d) Transmettre uniquement des données collectives et anonymes (« 11 participants en moyenne, 8 ont refait au moins deux recettes ») ; la liste nominative n'est pas nécessaire. e) Ne pas répondre sur Mme L. : « Je ne parle pas des absents ; chacun vient quand il le peut. » f) Possible sans nom ni photo identifiable, ou avec l'accord écrit des personnes citées ; ne mentionner aucune situation personnelle.
3. Notes sans nom de famille ni information de santé, rangées dans un dossier fermé au centre social ; fichier sur l'ordinateur de la structure, protégé par un mot de passe ; jamais sur un téléphone personnel ni dans une messagerie personnelle ; destruction à la fin du stage.

Corrigé – Exercice 6.10

1. L'équipe de soins rassemble les professionnels qui participent directement à la prise en charge d'une

même personne (ici les professionnels de la maison de santé impliqués dans le programme). Ils peuvent échanger les seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, la personne en étant informée et pouvant s'y opposer.

2. **Responsable de l'entreprise** : aucune information, même pas sa présence ; c'est un employeur et un financeur, hors équipe de soins. « Je ne peux donner aucune information sur les participants. Je peux vous transmettre le bilan collectif et anonyme du programme. » **Fille** : rien sans l'accord de sa mère. « Je ne peux pas vous répondre, mais votre maman peut vous en parler si elle le souhaite, ou vous pouvez l'accompagner à son prochain rendez-vous si elle est d'accord. » **Infirmière** : membre de l'équipe ; on peut lui signaler la difficulté d'accès à l'alimentation en fin de mois, utile à l'entretien, en informant Mme T. au préalable.
3. Revenir vers elle en privé, sans jugement : « Vous avez parlé du frigo vide en fin de mois ; est-ce que vous aimeriez qu'on en parle ? » Avec son accord, orienter vers l'assistante sociale de la maison de santé ou du CCAS, vers l'épicerie solidaire et vers des droits possibles (complémentaire santé solidaire, aides alimentaires) ; adapter les conseils de l'atelier à son budget.

Corrigé – Exercice 6.11

1. Ignorer la situation exposerait Noah à un danger possible : le secret ne s'oppose pas à la protection de l'enfance. Mais il ne revient pas au stagiaire de vérifier, d'interroger l'enfant de façon insistante ou de confronter la famille : cela pourrait mettre l'enfant en difficulté et gêner l'évaluation par les professionnels compétents.
2. Pendant l'atelier : rester calme et bienveillant, lui permettre de manger à sa faim, ne pas l'interroger devant le groupe, écouter s'il parle sans poser de questions qui orientent. Juste après : écrire les faits et ses paroles exactes, et en parler sans délai à la directrice de l'accueil de loisirs (et à sa tutrice). Les jours suivants : la directrice décide, avec les professionnels de la structure, de transmettre une information préoccupante à la CRIP ; en cas de danger grave et immédiat, appel au 17. Le stagiaire peut aussi appeler le 119 pour un conseil.
3. Exemple : « Mercredi 14 avril 2027, atelier petit-déjeuner, 9 h 30. Noah, 8 ans, a mangé quatre tartines rapidement. Il a dit : "À la maison, il n'y a jamais rien le matin, et le soir non plus." J'ai observé un bleu d'environ 3 cm sur l'avant-bras gauche. Il porte les mêmes vêtements depuis les ateliers du 31 mars et du 7 avril. Rédigé par [nom], stagiaire, le 14 avril à 12 h. »
4. « Tu as bien fait de me parler. Je ne peux pas garder ce secret, parce que mon travail, c'est que les enfants soient en sécurité. Je vais en parler à la directrice, pour qu'on puisse t'aider. »

Corrigé – Exercice 6.12

1. Pas de porc : 84 / 380 × 100 = **22,1 %** ; pas de viande : 31 / 380 × 100 = **8,2 %** ; ensemble : 115 / 380 × 100 = **30,3 %**.
2. Il faut **115** plats sans porc (84 + 31), dont au moins 31 sans viande. Pour simplifier, on peut servir ce jour-là un plat de remplacement végétarien unique, qui convient aux deux demandes, et le proposer à tous les enfants, sans liste affichée ni signe distinctif sur les plateaux. On peut aussi programmer moins souvent des plats avec porc.
3. La **neutralité** s'impose au service public et à ses agents : ils ne manifestent pas leurs convictions dans l'exercice de leurs fonctions (la collègue stagiaire, qui intervient dans un service public, adopte la même réserve : elle doit en parler à sa tutrice et respecter le règlement du service). Les **usagers** restent libres de leurs convictions : un parent peut demander un repas sans porc. Le service n'est pas tenu de répondre à toutes les demandes (la viande certifiée selon un rite n'est pas une obligation), mais il peut proposer des solutions générales (plat végétarien).
4. La phrase désigne l'enfant par sa religion devant les autres, fait une supposition et décide à sa place : elle est stigmatisante. Formulation : « Aujourd'hui, il y a deux plats : le rôti ou les lentilles. Lequel veux-tu ? »
5. Exemple : « La laïcité garantit la liberté de conscience de chaque famille et la neutralité du service ; elle

> n'impose pas de supprimer un plat de remplacement. Aujourd'hui, 115 enfants sur 380 (30 %) ne mangent pas le plat avec porc : sans remplacement, une partie d'entre eux ne mangerait que l'entrée et le dessert, ce qui nuit à leur alimentation. Un plat végétarien de remplacement, ouvert à tous, est simple, conforme à la loi EGalim et ne désigne personne. Je vous propose de le généraliser les jours où le plat contient du porc. »

Partie 3 – Protéger les données personnelles (RGPD)

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer donnée identifiante, pseudonymisée, anonymisée et agrégée.
- Citer les droits des personnes et y répondre.
- Appliquer les principes du RGPD à chaque étape d'une enquête.
- Repérer un risque de réidentification dans des résultats.
- Calculer des durées de conservation et tenir un registre simple.
- Analyser un outil numérique qui traite des données de santé.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- RGPD : règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018 ; en France, avec la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 ; contrôle par la CNIL.
- Donnée personnelle : information sur une personne identifiée ou identifiable, directement ou indirectement ; données de santé : catégorie particulière (article 9).
- Pseudonymisation : les données restent personnelles ; anonymisation : réidentification impossible, hors RGPD.
- Principes (article 5) : licéité, loyauté, transparence ; limitation des finalités ; minimisation ; exactitude ; limitation de la conservation ; intégrité et confidentialité ; responsabilité.
- Droits : information, accès, rectification, effacement, limitation, portabilité, opposition, retrait du consentement, réclamation à la CNIL ; réponse en principe dans un délai d'un mois (article 12).
- Sanctions : jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu (article 83).

Exercice 6.13 – De la donnée identifiante à la donnée agrégée (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez la saisie des questionnaires d'un atelier dans une association (fictive). La présidente vous demande ce que veut dire « anonyme ».

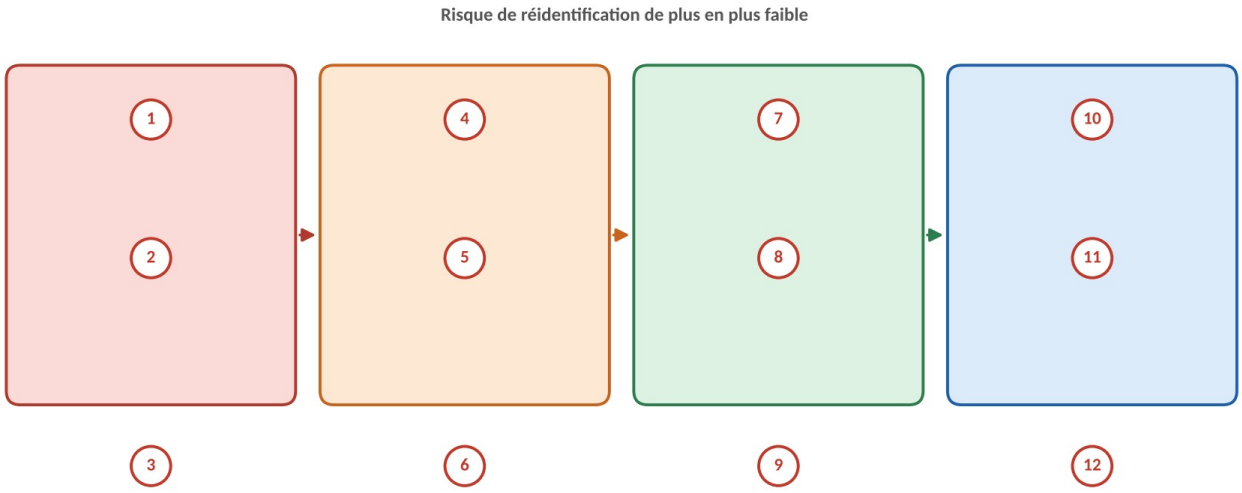


Figure 6.2 – Document 1 – De la donnée identifiante à la donnée agrégée (schéma à légender)

Document 2 – Six informations à classer

a) « Questionnaire n° 12 », avec un tableau séparé qui relie les numéros aux noms.

b) « 14 participants sur 18 ont refait une recette. »

c) Le prénom et le numéro de téléphone d'une participante.

d) Une base où les noms ont été supprimés, mais qui contient l'âge exact, la commune et la profession d'une personne d'un village de 200 habitants.

e) Une moyenne de satisfaction de 4,2 sur 5 pour 60 participants.

f) Une photo de groupe où les visages sont visibles.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (6 pts)
2. Classez les six informations du document 2 et dites si le RGPD s'applique. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi l'information d) n'est pas vraiment anonyme. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.14 – Répondre aux droits des personnes (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de prévention d'une mutuelle (fictive) organise des ateliers et tient un fichier des participants. Vous recevez plusieurs demandes.

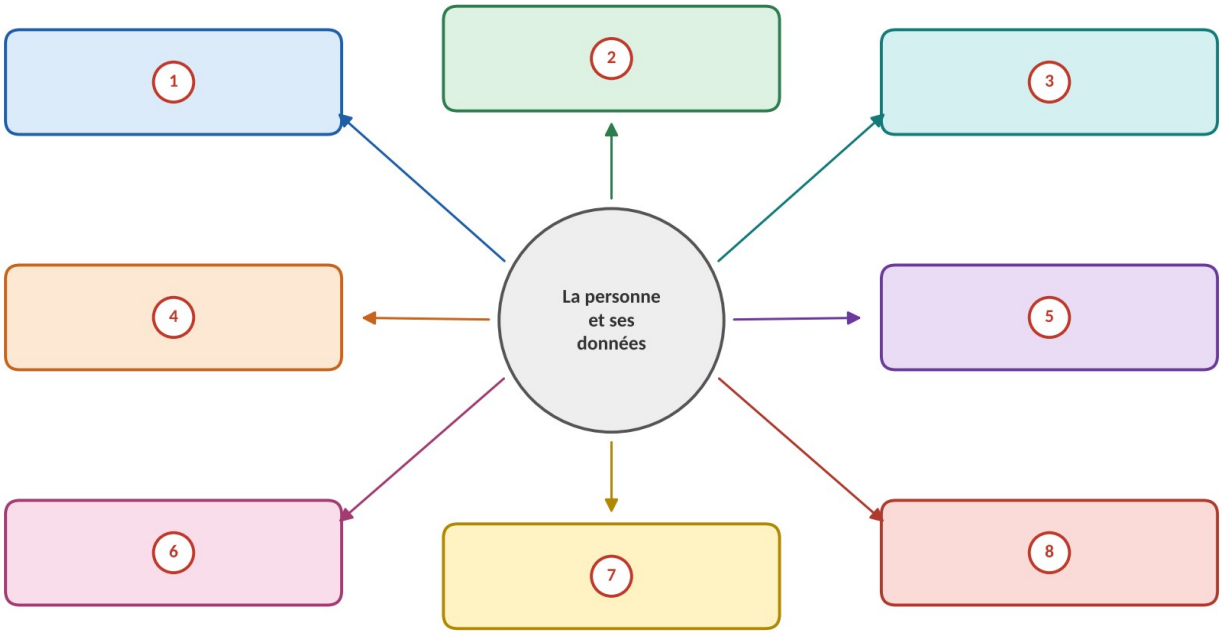


Figure 6.3 – Document 1 – Les droits des personnes sur leurs données (schéma à légender)

Document 2 – Six demandes reçues le 12 mai 2027

a) « Je veux savoir ce que vous avez noté sur moi. »

b) « Mon adresse a changé. »

c) « Je ne veux plus recevoir vos invitations, et je veux que vous supprimiez mes coordonnées. »

d) « J'avais accepté qu'on me photographie ; j'ai changé d'avis pour les prochaines publications. »

e) « Pourquoi me demandez-vous ma date de naissance ? »

f) « Vous ne me répondez pas : je vais me plaindre. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Associez chaque demande du document 2 à un droit. (3 pts)
3. Indiquez la date limite de réponse, en principe, aux demandes reçues le 12 mai 2027, et à qui la personne peut s'adresser si elle n'obtient pas de réponse. (2 pts)
4. Que devient une photo déjà publiée après le retrait du consentement ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.15 – Le cycle de vie des données d'une enquête (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour votre diagnostic de stage dans une résidence sociale pour jeunes (fictive), vous préparez une enquête sur les repas du soir auprès de 60 résidents.

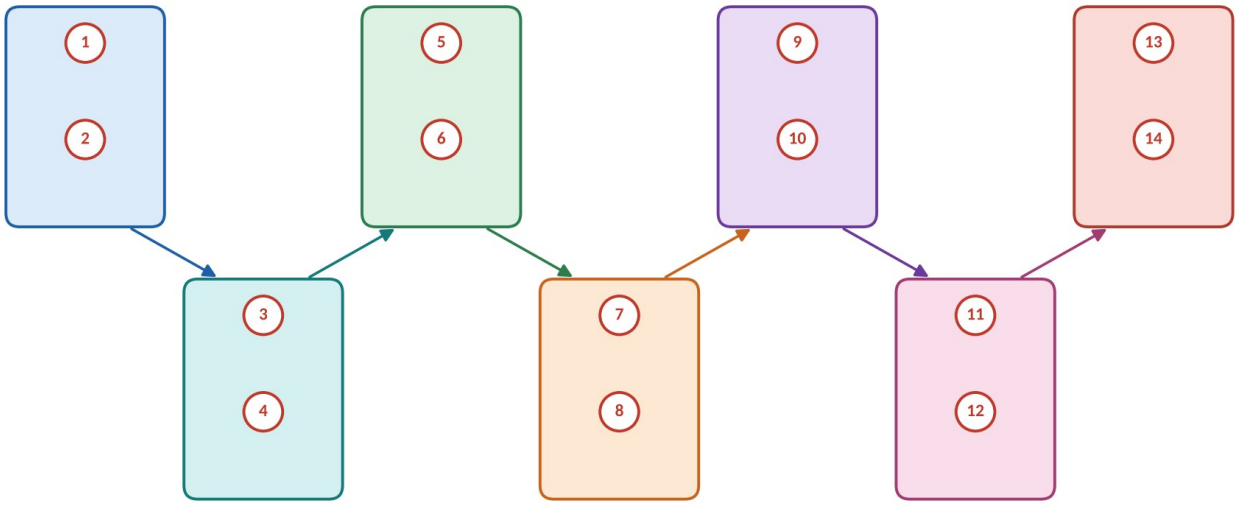


Figure 6.4 – Document 1 – Le cycle de vie des données d'une enquête (schéma à légender)

Document 2 – Votre projet de départ

Questionnaire papier avec nom et numéro de chambre « pour relancer ceux qui ne répondent pas » ; saisie sur votre ordinateur personnel ; envoi du fichier à votre formatrice par votre messagerie personnelle ; conservation « au cas où » ; résultats présentés au conseil de la vie sociale avec les citations des résidents.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 14 du document 1. (7 pts)
2. Relevez quatre problèmes du projet de départ et corrigez-les étape par étape. (4 pts)
3. Proposez une manière de relancer les résidents sans noter leur nom sur le questionnaire. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.16 – Des résultats qui identifient (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une infirmière scolaire (fictive) a mené une enquête anonyme sur le petit-déjeuner dans un collège. Elle souhaite publier ce tableau dans le journal du collège et sur l'espace numérique de travail.

Document 1 – Élèves qui déclarent ne jamais prendre de petit-déjeuner (données fictives)

Classe	Répondants	« Jamais de petit-déjeuner »
6e A	24	9
6e B	25	7
Unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS)	4	3
3e C	26	12
Ensemble	79	31

Commentaire prévu : « En 3e C, les trois élèves de la section sportive prennent tous un petit-déjeuner, contrairement aux autres. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages par classe et pour l'ensemble. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi ce tableau et ce commentaire peuvent permettre de réidentifier des élèves, alors que l'enquête était anonyme. (3 pts)
3. Proposez une présentation qui protège les élèves et calculez le nouveau résultat, en regroupant les élèves de 6e et de l'ULIS. (3 pts)
4. Citez deux autres précautions avant toute publication. (2 pts)
5. Qui doit valider la publication ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.17 – Dates de conservation et registre (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calculs · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous terminez votre stage dans un centre social (fictif) et vous devez remettre à la structure le bilan des données que vous avez recueillies.

Document 1 – Les traitements réalisés pendant le stage

Traitement	Date de fin de recueil	Durée de conservation décidée avec la tutrice
Questionnaires de diagnostic (papier, anonymes)	18 mars 2027	6 mois après la fin du recueil, puis destruction
Fichier de saisie des questionnaires	30 juin 2027	3 mois après l'épreuve E5, prévue le 30 juin 2027
Autorisations de droit à l'image	5 novembre 2027	2 ans à partir de la signature
Liste des inscrits aux ateliers (prénom, téléphone)	12 mai 2027	1 mois après le dernier atelier

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la date de suppression de chaque traitement. (4 pts)
2. Le 18 septembre 2027 tombe un samedi, jour de fermeture du centre. Que proposez-vous ? (1 pt)
3. Rédigez la fiche de registre du traitement « Liste des inscrits aux ateliers » : finalité, catégories de données, personnes concernées, destinataires, durée, mesures de sécurité. (5 pts)
4. Pourquoi faut-il fixer la durée avant de collecter les données, et non après ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.18 – Une application de suivi alimentaire dans un programme de prévention (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté d'agglomération (fictive) lance un programme de prévention du diabète de type 2 pour 300 adultes à risque, orientés par leur médecin. Un prestataire propose une application : photo des repas, poids hebdomadaire, nombre de pas, glycémie capillaire facultative, messagerie avec un coach, classement des participants « pour motiver ». Les données seraient hébergées par une société hors de l'Union européenne et conservées 10 ans « pour la recherche ».

Document 1 – Repères (données réelles)

- RGPD, article 9 : le traitement des données de santé est interdit, sauf exceptions (consentement explicite, prise en charge sanitaire, intérêt public dans le domaine de la santé…).
- RGPD, article 35 : analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) si risque élevé ; d'après les lignes directrices européennes reprises par la CNIL, en principe dès que deux critères sur neuf sont réunis : évaluation ou notation des personnes ; décision automatisée ; surveillance systématique ; données sensibles ; grande échelle ; croisement de données ; personnes vulnérables ; usage innovant ; traitement qui empêche d'exercer un droit ou de bénéficier d'un service.
- Code de la santé publique, article L. 1111-8 : les hébergeurs de données de santé à caractère personnel doivent être certifiés (certification HDS).

À vous de jouer – Questions

1. Listez les données de santé traitées par l'application. (2 pts)

2. Comptez les critères d'AIPD réunis et concluez. (4 pts)

3. Relevez cinq problèmes du projet au regard du RGPD et de l'éthique (non-malfaisance, autonomie). (5 pts)

4. Proposez cinq conditions à exiger du prestataire avant toute signature. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 6.13

1. Légendes : 1 Donnée identifiante ; 2 nom, téléphone, photo, numéro d'étudiant ; 3 RGPD applicable ; 4 Donnée pseudonymisée ; 5 nom remplacé par un code ; une clé permet de retrouver la personne ; 6 RGPD applicable ; 7 Donnée anonymisée ; 8 réidentification impossible, de façon irréversible ; 9 hors RGPD ; 10 Donnée agrégée ; 11 « 8 participants sur 12 » : résultat collectif ; 12 hors RGPD si effectifs suffisants.
2. a) pseudonymisée (la table de correspondance permet de retrouver la personne) : RGPD applicable. b) agrégée : hors RGPD. c) identifiante : RGPD applicable. d) pseudonymisée en apparence, en fait identifiable : RGPD applicable. e) agrégée : hors RGPD. f) identifiante (visages) : RGPD et droit à l'image.
3. Dans un village de 200 habitants, la combinaison de l'âge exact, de la commune et de la profession désigne très probablement une seule personne : on peut la retrouver sans son nom. L'anonymisation suppose de supprimer ou de regrouper ces informations (tranches d'âge, territoire plus large).

Corrigé – Exercice 6.14

1. Légendes : 1 Information ; 2 Accès ; 3 Rectification ; 4 Effacement ; 5 Opposition ; 6 Retrait du consentement ; 7 Portabilité ; 8 Réclamation auprès de la CNIL.
2. a) accès ; b) rectification ; c) opposition (aux invitations) et effacement ; d) retrait du consentement ; e) information (savoir pourquoi la donnée est collectée ; la question invite aussi à vérifier la minimisation) ; f) réclamation auprès de la CNIL.
3. En principe un mois : le **12 juin 2027** (le délai peut être prolongé de deux mois pour des demandes complexes ou nombreuses, en informant la personne). Sans réponse, la personne peut saisir la CNIL.
4. Le retrait vaut pour l'avenir : la photo n'est plus utilisée dans de nouvelles publications, et la structure la retire des supports qu'elle maîtrise (site, page de réseau social) ; les documents déjà imprimés et distribués ne peuvent pas être rappelés.

Corrigé – Exercice 6.15

1. Légendes : 1 Finalité ; 2 un objectif précis, écrit avant de collecter ; 3 Minimisation ; 4 seulement les questions utiles ; anonymat si possible ; 5 Information ; 6 qui, pourquoi, combien de temps, droits, contact ; 7 Sécurité ; 8 accès limité, mot de passe, hébergement dans l'UE ; 9 Analyse ; 10 résultats collectifs, pas de cas identifiable ; 11 Restitution ; 12 résultats rendus aux participants et à la structure ; 13 Suppression ; 14 à la date prévue, papier détruit, fichier effacé.
2. Nom et numéro de chambre : contraires à la minimisation, inutiles pour l'analyse ; questionnaire anonyme. Saisie sur l'ordinateur personnel et envoi par messagerie personnelle : contraires à la sécurité ; saisie sur un poste de la structure, envoi à la formatrice de résultats agrégés seulement. Conservation « au cas où » : contraire à la limitation de la conservation ; date de suppression fixée et inscrite dans la mention d'information. Citations des résidents au conseil de la vie sociale : risque de reconnaissance dans une petite résidence ; citations courtes, sans détail identifiant, et seulement si les résidents ont été informés.
3. Urne anonyme et affiche de relance générale (« Il reste une semaine pour répondre ») ; relance collective lors du repas partagé ; on compte les questionnaires reçus sans savoir qui a répondu.

Corrigé – Exercice 6.16

1. 6e A : 9 / 24 = **37,5 %** ; 6e B : 7 / 25 = **28,0 %** ; ULIS : 3 / 4 = **75,0 %** ; 3e C : 12 / 26 = **46,2 %** ; ensemble : 31 / 79 = **39,2 %**.
2. Dans le groupe ULIS, 4 élèves seulement ont répondu : « 3 sur 4 » permet presque de savoir qui ne déjeune pas, et l'élève qui déjeune peut être reconnu. Le commentaire sur les trois élèves de la section

sportive les désigne directement et permet de déduire la réponse des autres. Une enquête anonyme peut produire des résultats identifiants quand les effectifs sont petits ou quand on croise plusieurs informations.

3. Présentation par niveau : 6e et ULIS regroupés : (9 + 7 + 3) / (24 + 25 + 4) = 19 / 53 = **35,8 %** ; 3e : 46,2 % ; ensemble 39,2 % ; suppression du commentaire sur la section sportive. Règle pratique : ne pas publier de résultat calculé sur moins de 5 à 10 personnes.
4. Retirer toute citation ou détail qui permettrait de reconnaître un élève ; présenter les résultats de façon positive, sans stigmatiser une classe ; faire relire par une personne extérieure à l'enquête.
5. Le chef d'établissement, responsable du traitement, avec l'avis de l'infirmière ; en cas de doute, le délégué à la protection des données de l'académie.

Corrigé – Exercice 6.17

1. Questionnaires : 18 mars 2027 + 6 mois = **18 septembre 2027**. Fichier : 30 juin 2027 + 3 mois = **30 septembre 2027**. Autorisations : 5 novembre 2027 + 2 ans = **5 novembre 2029**. Liste des inscrits : 12 mai 2027 + 1 mois = **12 juin 2027**.
2. Détruire les questionnaires le dernier jour ouvré avant l'échéance, le vendredi 17 septembre 2027 ; on peut détruire plus tôt, jamais plus tard.
3. Exemple : « Liste des inscrits aux ateliers. Finalité : organiser les ateliers et prévenir les participants en cas de changement. Données : prénom, numéro de téléphone. Personnes concernées : adultes inscrits aux ateliers cuisine du printemps 2027. Destinataires : l'animatrice et la référente familles du centre social. Durée : jusqu'au 12 juin 2027 (un mois après le dernier atelier), puis suppression. Sécurité : liste papier rangée dans l'armoire fermée du bureau ; fichier sur le poste de la structure, protégé par un mot de passe ; aucune copie sur un téléphone personnel. »
4. La durée fait partie de l'information donnée aux personnes au moment de la collecte : elles doivent savoir à l'avance combien de temps leurs données seront gardées. La fixer avant oblige aussi à se demander de quoi on a réellement besoin, et évite la conservation « au cas où ».

Corrigé – Exercice 6.18

1. Données de santé : poids, glycémie capillaire, photos des repas associées à une personne à risque de diabète, et le fait même de participer à un programme de prévention du diabète ; le nombre de pas devient aussi une donnée de santé quand il sert à suivre l'état de santé.
2. Critères réunis : évaluation ou notation des personnes (classement) ; surveillance systématique (suivi hebdomadaire) ; données sensibles (santé) ; grande échelle possible (300 personnes, puis davantage) ; croisement de données (repas, poids, pas, glycémie) ; personnes vulnérables (personnes à risque, parfois en situation sociale fragile) ; usage innovant (application et coach à distance). Au moins **six critères sur neuf** : l'AIPD est **obligatoire** avant toute mise en œuvre.
3. Hébergement hors de l'Union européenne sans garanties précisées, et sans certification HDS ; conservation de 10 ans « pour la recherche », finalité différente et non définie ; classement des participants, qui risque la stigmatisation, la compétition et la restriction alimentaire (non-malfaisance) ; collecte large (photos de tous les repas, poids chaque semaine) contraire à la minimisation ; consentement des personnes orientées par leur médecin, qui peut ne pas être libre si elles pensent que la participation conditionne leur suivi (autonomie).
4. Conditions : AIPD réalisée et validée par le délégué à la protection des données ; hébergeur certifié HDS, données hébergées dans l'Union européenne ; suppression du classement et de toute fonction de comparaison entre participants ; collecte limitée aux données utiles, glycémie et photos facultatives, possibilité de participer au programme sans l'application ; durée de conservation limitée à la durée du programme plus une courte période, toute recherche ultérieure faisant l'objet d'une information et d'un cadre propres ; contrat précisant que le prestataire n'utilise pas les données à d'autres fins.

Partie 4 – Le consentement et le droit à l'image

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les quatre qualités d'un consentement valable et le droit de retrait.
- Décider si une photo peut être prise et diffusée, et avec quelle autorisation.
- Rédiger une autorisation de droit à l'image conforme.
- Recueillir l'accord de personnes vulnérables et de mineurs.
- Organiser une vidéo de valorisation qui respecte chacun.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Consentement (RGPD, article 4) : libre, spécifique, éclairé, univoque ; une case pré-cochée ou le silence ne valent pas consentement ; retrait possible à tout moment, aussi facilement que le consentement a été donné (article 7).
- Participation à une action de santé : libre, sans conséquence en cas de refus ; information sur les objectifs, le déroulement, les allergènes, l'usage des données.
- Droit à l'image : article 9 du Code civil (vie privée) ; article 226-1 du Code pénal (captation dans un lieu privé sans consentement).
- Autorisation écrite : identité, objet, supports cochés un par un, durée, territoire, gratuité, retrait, signature datée ; mineur : les deux titulaires de l'autorité parentale, avec l'avis de l'enfant.
- Personne protégée (tutelle, curatelle) : elle prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet (article 459 du Code civil).

Exercice 6.19 – Les qualités du consentement (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous relisez avec votre tutrice les documents d'inscription d'un programme d'ateliers dans une maison de santé (fictive).

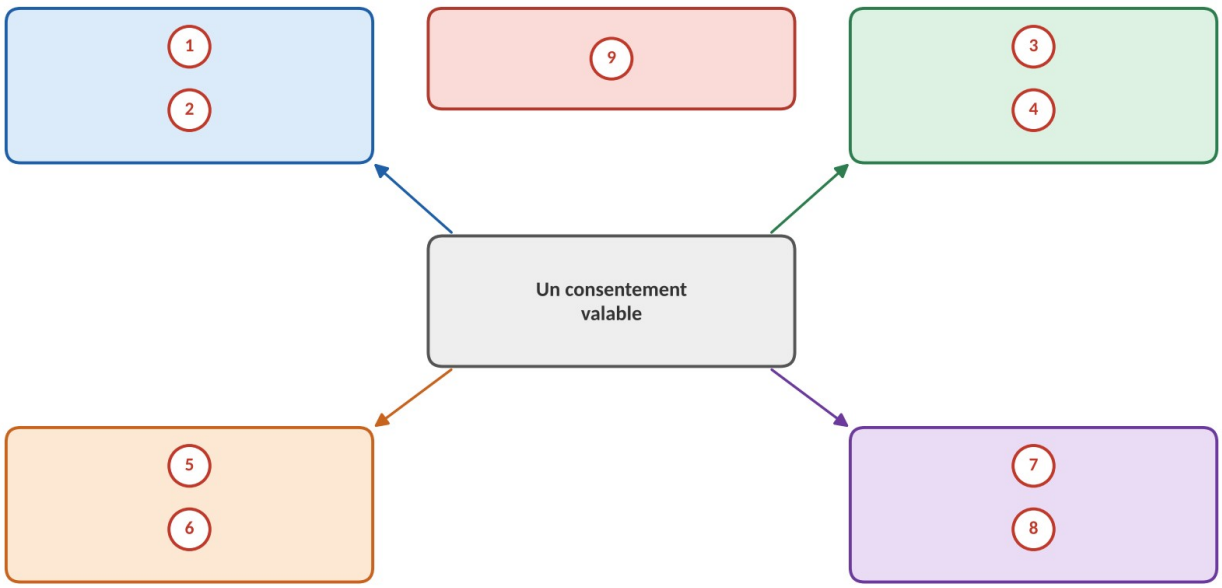


Figure 6.5 – Document 1 – Les qualités d'un consentement valable (schéma à légender)

Document 2 – Six manières de recueillir un accord

a) Une case « J'accepte que mes coordonnées soient transmises aux partenaires » déjà cochée.

b) Une seule signature pour « participer aux ateliers, être photographié et recevoir la lettre d'information ».

c) Une fiche qui explique le programme, puis trois cases séparées que la personne coche elle-même.

d) « Si vous ne répondez pas sous huit jours, nous considérons que vous acceptez. »

e) « Les participants qui refusent les photos ne pourront pas venir à la sortie au marché. »

f) Un accord oral pour goûter, demandé à chaque dégustation.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)
2. Pour chaque manière du document 2, dites si l'accord est valable et quelle qualité manque. (4,5 pts)
3. Comment une personne peut-elle retirer son consentement dans ce programme ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.20 – Peut-on prendre cette photo ? (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous voulez illustrer votre dossier E5 et la page de la structure qui vous accueille, une association de quartier (fictive).

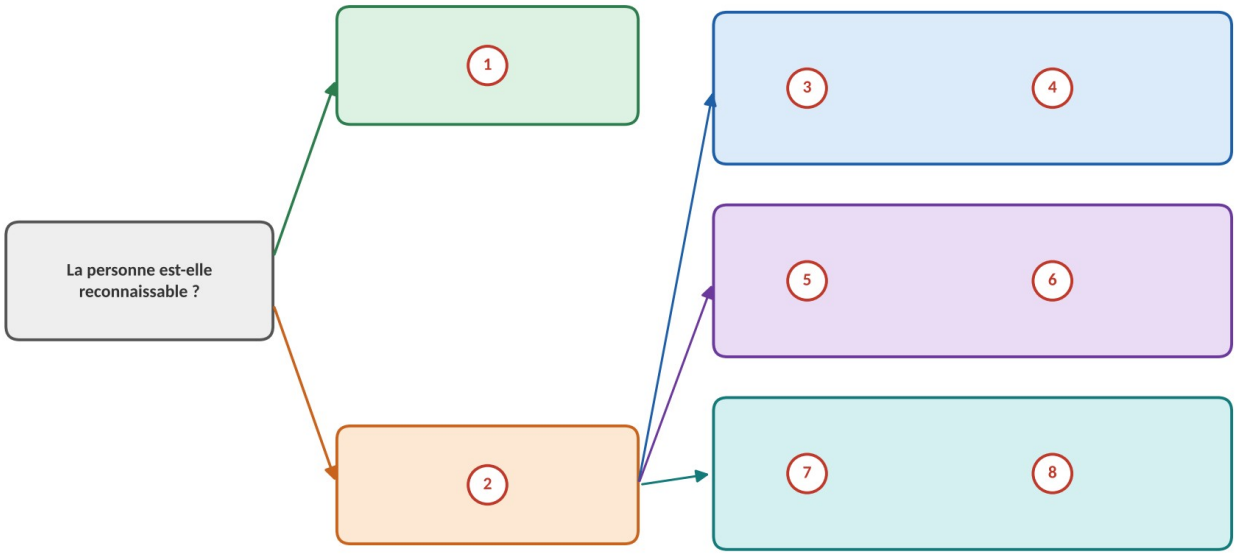


Figure 6.6 – Document 1 – Prendre ou diffuser une photo pendant une action (schéma à légender)

Document 2 – Six photos envisagées

a) Les mains d'une participante qui pétrit une pâte.

b) Un groupe de six adultes souriants autour du plan de travail, visages visibles.

c) Une enfant de 9 ans qui goûte une soupe ; seule sa mère a signé l'autorisation.

d) Le buffet de fin d'atelier, sans personne.

e) Un adulte sous curatelle, qui accepte avec plaisir d'être photographié et comprend l'usage prévu.

f) Une photo de dos d'un participant devant la façade d'un centre d'addictologie.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Pour chaque photo du document 2, indiquez si elle est possible et à quelles conditions. (5 pts)
3. Pourquoi la photo f) pose-t-elle problème même si le visage n'est pas visible ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.21 – Corriger une autorisation de droit à l'image (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre social où vous êtes en stage (fictif) utilise depuis plusieurs années le formulaire ci-dessous. La directrice vous demande de le mettre à jour.

Document 1 – Le formulaire actuel

« AUTORISATION. Je soussigné(e) _____ autorise le centre social à utiliser mon image et celle de mes enfants sur tous les supports, présents et futurs, sans limitation de durée. Signature : _____ »

Le formulaire est remis en fin d'atelier, quand les photos ont déjà été prises. Il est signé par un seul parent pour les enfants.

À vous de jouer – Questions

1. Relevez six défauts du formulaire et de son usage. (3 pts)
2. Rédigez une nouvelle autorisation pour un adulte et ses enfants mineurs (environ 15 lignes), avec des cases à cocher. (7 pts)
3. Expliquez comment adapter ce formulaire pour un public qui lit peu le français. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.22 – Le consentement des personnes vulnérables (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez des ateliers « plaisir de manger » dans un EHPAD (fictif). Plusieurs résidents ont des troubles cognitifs ; certains bénéficient d'une mesure de protection juridique.

Document 1 – Quatre situations

a) M. A., 86 ans, maladie d'Alzheimer modérée, sans mesure de protection : il dit « oui » à l'atelier mais semble ne pas comprendre de quoi il s'agit ; il manifeste de l'agitation quand on l'installe en cuisine.

b) Mme B., 91 ans, sous tutelle, comprend bien l'atelier et souhaite y participer ; sa fille, qui n'est pas sa tutrice, s'y oppose « parce qu'elle va se fatiguer ».

c) Mme C., 79 ans, sous curatelle, accepte d'être filmée pour un reportage de la télévision locale.

d) M. D., 88 ans, a désigné son fils comme personne de confiance ; il ne s'exprime plus verbalement mais sourit et tend les mains vers les fruits.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi un « oui » ne suffit pas toujours, et ce que signifie rechercher l'assentiment. (3 pts)
2. Pour chaque situation, proposez une conduite à tenir et justifiez-la. (8 pts)
3. Qui associez-vous, dans l'équipe de l'EHPAD, à ces décisions ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.23 – Une enquête auprès de collégiens (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calculs et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre de votre stage au service de promotion de la santé d'un département (fictif), vous menez une enquête anonyme sur les boissons auprès de deux classes de 4e, soit 58 élèves.

Document 1 – Déroulement (données fictives)

- Une lettre d'information a été remise aux familles dix jours avant, avec un coupon d'opposition.
- 6 familles ont renvoyé le coupon d'opposition.
- Le jour de l'enquête, 4 élèves autorisés étaient absents, et 9 élèves autorisés ont refusé de répondre après l'explication en classe.
- Les autres élèves ont rempli le questionnaire.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de répondants, le taux de participation sur l'ensemble des élèves, la part d'oppositions des familles, la part de refus parmi les élèves autorisés et le taux de participation parmi les élèves autorisés et présents. (4 pts)

2. Expliquez pourquoi on recueille à la fois l'information des parents et l'accord des élèves. (2 pts)

3. Rédigez les trois phrases que vous dites en classe avant de distribuer le questionnaire. (3 pts)

4. Que proposez-vous aux élèves qui ne participent pas, pendant le temps de l'enquête ? (1 pt)

5. Les élèves qui refusent sont-ils comparables à ceux qui répondent ? Quel biais cela peut-il créer ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.24 – Une vidéo de valorisation qui respecte chacun (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association d'aide alimentaire (fictive) veut réaliser une vidéo de deux minutes sur ses ateliers cuisine pour la présenter à ses financeurs et la publier sur sa page de réseau social. Vingt-deux personnes participent aux ateliers.

Document 1 – Les réponses des participants (données fictives)

- 15 acceptent d'apparaître visage visible ;
- 4 acceptent d'apparaître sans que l'on voie leur visage (mains, dos) ;
- 3 refusent d'être filmés.
- Deux participants acceptent pour la présentation aux financeurs, mais pas pour le réseau social.
- Une bénévole souhaite ajouter un commentaire : « Ces familles n'avaient jamais cuisiné de légumes avant de venir chez nous. »
- Le supermarché qui donne une partie des denrées demande que son logo apparaisse à la fin de la vidéo.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part des participants dans chaque situation et la part de ceux qui peuvent apparaître d'une manière ou d'une autre. (3 pts)
2. Organisez le tournage pour respecter les trois choix (placement, cadrage, moments filmés). (4 pts)
3. Comment gérer les deux participants qui refusent le réseau social ? (2 pts)
4. Analysez la phrase de la bénévole et proposez une autre formulation. (3 pts)
5. Le logo du supermarché peut-il apparaître ? À quelles conditions ? (2 pts)
6. Citez deux règles d'accessibilité pour la vidéo publiée. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 6.19

1. Légendes : 1 Libre ; 2 sans pression ni contrepartie ; refuser sans conséquence ; 3 Spécifique ; 4 un accord pour chaque usage (rapport, affiche, réseau social) ; 5 Éclairé ; 6 information claire : qui, quoi, pourquoi, combien de temps ; 7 Univoque ; 8 un acte positif : case cochée par la personne, signature ; 9 retrait possible à tout moment, aussi facilement.
2. a) Non valable : pas d'acte positif (univoque). b) Non valable : un accord global pour des usages différents (spécifique). c) Valable : information, puis accords séparés cochés par la personne. d) Non valable : le silence ne vaut pas consentement (univoque). e) Non valable : la sanction en cas de refus supprime la liberté (libre). f) Valable : accord simple, renouvelé, pour un acte précis.
3. Par un simple message oral ou écrit à l'animatrice ou à l'accueil, aussi facilement qu'il a été donné ; la structure note le retrait et cesse l'usage concerné pour l'avenir.

Corrigé – Exercice 6.20

1. Légendes : 1 Non (mains, plats, dos, supports) : possible avec un accord oral ; 2 Oui : autorisation écrite préalable ; 3 Majeur ; 4 signature de la personne ; 5 Mineur ; 6 deux titulaires de l'autorité parentale + avis de l'enfant ; 7 Contenu ; 8 supports cochés un à un, durée, gratuité, retrait.
2. a) Possible, avec un accord oral, en évitant bijoux ou tatouages reconnaissables. b) Possible seulement avec l'autorisation écrite des six adultes, support par support ; sinon recadrer ou flouter. c) Pas possible en l'état : il manque l'accord du second parent ; photographier sans son visage ou attendre l'autorisation complète. d) Possible sans autorisation. e) Possible : la personne sous curatelle décide seule pour son image si elle comprend et accepte ; on recueille sa signature et on peut informer le curateur, par prudence, si la structure le prévoit. f) Non : le lieu révèle une information de santé (suivi en addictologie) ; la personne peut être reconnue par ses proches même de dos.
3. L'image associe la personne à un lieu de soins : c'est une donnée de santé indirecte, et une personne de dos reste souvent reconnaissable (silhouette, vêtements, contexte).

Corrigé – Exercice 6.21

1. Défauts : aucun objet ni contexte précis ; « tous les supports » sans choix ; « présents et futurs » ; « sans limitation de durée » ; pas de mention de gratuité ni du droit de retrait ; formulaire remis après les photos (accord non préalable) ; un seul parent pour les enfants ; aucun avis de l'enfant ; pas de contact ni de date.
2. Exemple : « Autorisation de prise de vue et de diffusion. Je soussigné(e) [nom, prénom], agissant pour moi-même et, avec l'autre titulaire de l'autorité parentale, pour mes enfants [prénoms], autorise le centre social [nom] à photographier et filmer pendant les ateliers cuisine du [dates]. J'accepte la diffusion (cocher chaque case) : [ ] dans le rapport de stage et le dossier d'examen de la stagiaire ; [ ] sur les affiches du centre social ; [ ] sur le site internet du centre social ; [ ] sur sa page de réseau social. Durée : 2 ans à partir de la signature, en France. Cette autorisation est gratuite. Je peux la retirer à tout moment, pour l'avenir, en le disant à l'accueil. Mes enfants ont été informés et sont d'accord : [ ] oui. Fait à [lieu], le [date]. Signature du parent 1 ; signature du parent 2. Contact : [accueil du centre social]. »
3. Expliquer oralement le formulaire, avec un exemple de chaque support (une affiche, la page du site sur un téléphone) ; utiliser des pictogrammes pour chaque case ; proposer une traduction ou l'aide d'une personne relais ; vérifier la compréhension par le « faire dire » avant la signature.

Corrigé – Exercice 6.22

1. Un « oui » n'est valable que si la personne comprend ce qu'on lui propose et peut exprimer un choix. Chez une personne qui a des troubles cognitifs, on recherche son **assentiment** : on adapte l'explication, on

observe ses réactions (plaisir, refus, agitation), on renouvelle la question à chaque séance et on respecte un refus, même non verbal.

2. a) L'agitation montre un refus ou un malaise : ne pas insister ; proposer une autre forme de participation (goûter, sentir des aromates dans un lieu calme), en parler avec l'équipe soignante. b) Mme B. comprend et souhaite participer : sa volonté prime pour une décision qui concerne sa personne (article 459 du Code civil) ; sa fille n'a pas de pouvoir de décision ; on l'écoute, on adapte (durée courte, pause) et on explique la décision. c) Une personne sous curatelle décide seule pour son image si elle comprend l'usage ; on s'assure qu'elle a compris qu'il s'agit d'une diffusion publique, on lui laisse un délai de réflexion et on informe le curateur si l'établissement le prévoit ; la direction de l'EHPAD valide le tournage. d) Le sourire et les gestes vers les fruits expriment une envie de participer : on recherche son assentiment à chaque séance ; la personne de confiance peut être consultée sur ses goûts et ses habitudes, mais elle ne décide pas à sa place pour une activité de la vie quotidienne.

3. Le médecin coordonnateur, l'infirmière coordinatrice, le psychologue de l'établissement et l'équipe soignante qui connaît les résidents ; la direction pour les tournages.

Corrigé – Exercice 6.23

1. Élèves autorisés : 58 − 6 = 52 ; présents : 52 − 4 = 48 ; répondants : 48 − 9 = **39**. Taux de participation : 39 / 58 = **67,2 %**. Oppositions des familles : 6 / 58 = **10,3 %**. Refus parmi les autorisés : 9 / 52 = **17,3 %**. Participation parmi les autorisés et présents : 39 / 48 = **81,3 %**.

2. Les parents, titulaires de l'autorité parentale, doivent être informés et pouvoir s'opposer ; mais l'élève, qui répond lui-même, doit aussi être libre de participer : un adolescent de 13 ou 14 ans peut comprendre l'enquête et refuser, et son choix est respecté.

3. Exemple : « Ce questionnaire porte sur ce que vous buvez dans la journée ; il est anonyme : n'écrivez pas votre nom, personne ne saura qui a répondu quoi. Vous êtes libres de répondre ou non, et de ne pas répondre à certaines questions ; il n'y a ni note ni bonne réponse. Les résultats de la classe vous seront présentés dans un mois. »

4. Une activité calme sans lien avec l'enquête (lecture, exercice de l'enseignant), sans que leur refus soit visible pour les autres.

5. Pas forcément : les élèves qui refusent ou dont les parents s'opposent peuvent avoir des habitudes différentes (par exemple consommer davantage de boissons sucrées et ne pas vouloir en parler). Cela crée un **biais de sélection** (ou de non-réponse) : le résultat peut sous-estimer ou surestimer la consommation réelle.

Corrigé – Exercice 6.24

1. Visage visible : 15 / 22 = **68,2 %** ; sans visage : 4 / 22 = **18,2 %** ; refus : 3 / 22 = **13,6 %** ; peuvent apparaître d'une manière ou d'une autre : 19 / 22 = **86,4 %**.

2. Placer les trois personnes qui refusent hors du champ (poste de travail au fond, rôle de préparation) ou filmer à un moment où elles ne sont pas présentes ; filmer les quatre personnes « sans visage » en gros plan sur les mains ou de dos, sans signe distinctif ; vérifier chaque plan au montage ; ne jamais filmer les participants pendant la distribution des denrées.

3. Réaliser deux versions : une version pour les financeurs (diffusion privée, avec ces deux personnes) et une version publique où elles n'apparaissent pas ou ne sont pas reconnaissables ; noter clairement les choix sur la liste des autorisations.

4. La phrase présente les familles comme incapables et dépendantes de l'association : elle est stigmatisante et inexacte (beaucoup savent cuisiner). Exemple : « Chaque semaine, on partage nos recettes et on découvre ensemble de nouvelles façons de cuisiner les légumes. »

5. Oui, si l'association l'accepte et le décide elle-même : mention sobre du soutien (« avec le soutien de… »), sans produit de marque mis en avant ni message publicitaire, et transparence sur le partenariat. Sur la

page de l'association, une contrepartie commerciale doit être clairement signalée.

6. Sous-titres pour les personnes sourdes ou malentendantes (et pour le visionnage sans le son) ; description audio ou commentaire qui décrit les gestes pour les personnes aveugles ; texte en écriture claire.

Partie 5 – Conflits d'intérêts et partenariats

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer lien d'intérêts et conflit d'intérêts.
- Gérer un lien d'intérêts en cinq temps.
- Classer des propositions de partenariat (acceptable, à encadrer, à refuser).
- Calculer la part d'un financement privé et rédiger les clauses d'une convention.
- Appliquer le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (OMS, 1981).
- Lire une déclaration publique d'intérêts.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Conflit d'intérêts : situation où un intérêt secondaire (financier, professionnel, personnel) peut influencer, ou paraître influencer, le jugement d'un professionnel au détriment de son intérêt primaire (la santé des personnes).
- Un lien d'intérêts n'est pas une faute : c'est l'absence de déclaration et de gestion qui pose problème.
- Loi du 29 décembre 2011 (dite loi Bertrand) : publication des liens entre industries de santé et professionnels sur la base Transparence Santé ; déclaration publique d'intérêts (DPI) des experts des agences.
- Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (OMS, 1981) : pas de promotion auprès du public, pas d'échantillons gratuits aux mères.
- Partenariat acceptable : convention écrite, contenus décidés par le professionnel, pas de logo sur une campagne de santé, pas de produit de marque mis en avant, transparence.

Exercice 6.25 – Gérer un lien d'intérêts (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une fiche méthode pour les animateurs d'un réseau de prévention (fictif), souvent sollicités par des entreprises.

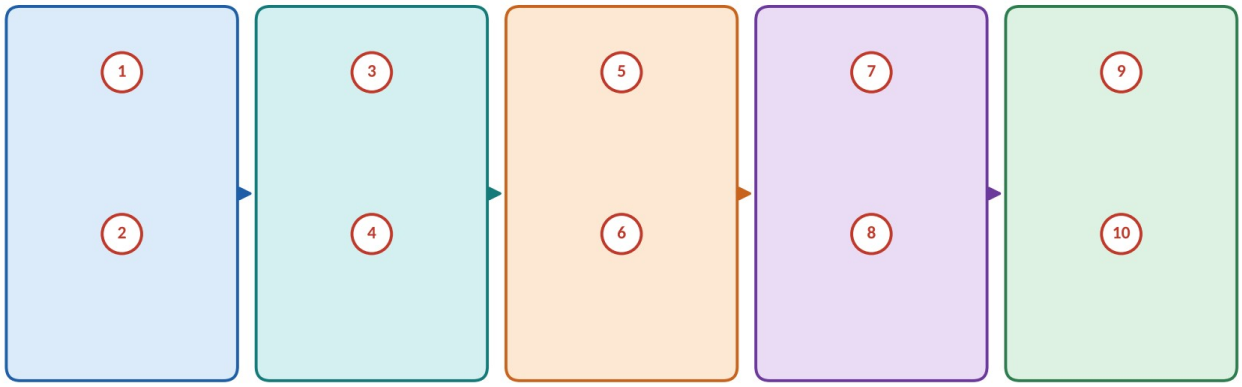


Figure 6.7 – Document 1 – Gérer un lien d'intérêts en cinq temps (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (5 pts)

2. Définissez le conflit d'intérêts et expliquez la différence avec un lien d'intérêts. (3 pts)

3. Donnez un exemple de lien d'intérêts personnel (et non financier) dans une action de nutrition. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.26 – Le feu tricolore des partenariats (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le comité de pilotage d'un projet « bien manger au collège » (fictif) a reçu huit propositions de soutien. Il vous demande de les classer.

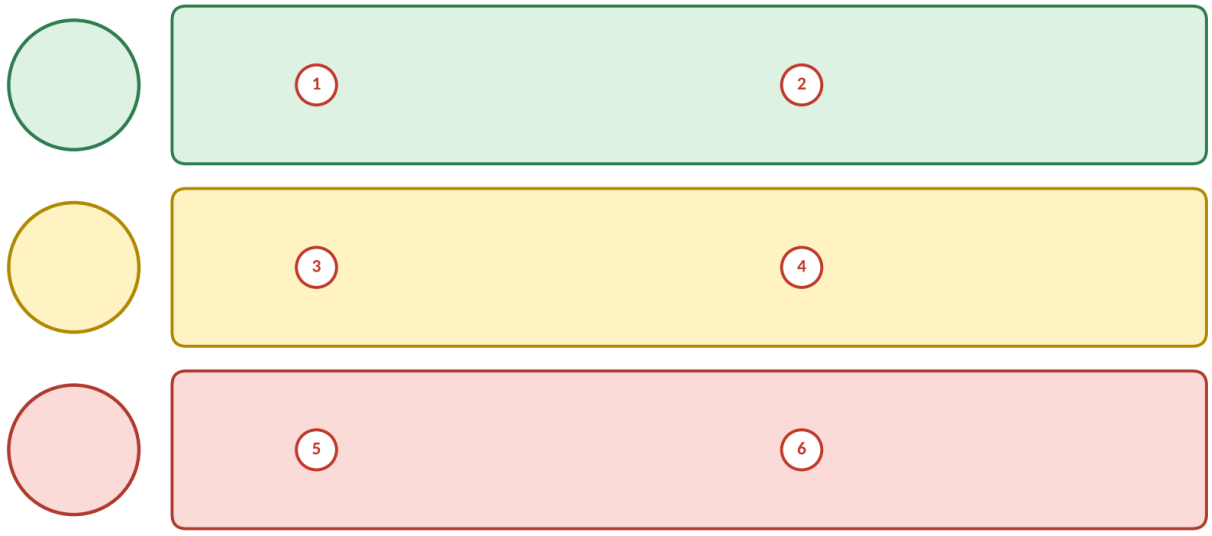


Figure 6.8 – Document 1 – Le feu tricolore des partenariats (schéma à légender)

Document 2 – Huit propositions

a) Le conseil départemental finance l'achat de matériel de cuisine.

b) Une marque de sodas offre des gourdes à son logo pour tous les élèves.

c) Le marché de producteurs locaux donne des fruits et légumes invendus pour les ateliers.

d) Une interprofession agricole fournit des fiches pédagogiques sur ses produits.

e) Une enseigne de restauration rapide propose de financer un concours de recettes, avec son logo sur les affiches.

f) Une banque propose un mécénat de 500 € sans contrepartie publicitaire.

g) Une application de « coaching » propose un accès gratuit aux élèves en échange de leurs adresses électroniques.

h) Santé publique France met à disposition ses affiches et ses outils.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Classez les huit propositions du document 2 en vert, orange ou rouge, en justifiant en une phrase. (6 pts)
3. Pour une proposition orange, indiquez ce qu'il faut vérifier ou négocier. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.27 – La part d'un financement privé (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calculs et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de quartier (fictive) prépare un projet d'ateliers « cuisine et santé » d'un an. Le budget total est de 4 800 €.

Document 1 – Plan de financement (données fictives)

Financeur	Montant	Contrepartie demandée
Ville	2 000 €	Bilan annuel
Caisse d'allocations familiales	1 200 €	Bilan, participation de familles allocataires
Industriel de produits laitiers	1 000 €	Logo sur les supports, présentation de ses produits lors d'un atelier
Fondation d'une enseigne de distribution	600 €	Mention du soutien dans le rapport annuel
Total	**4 800 €**	

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de chaque financeur et la part du financement privé. (3 pts)
2. Analysez les risques liés au financement de l'industriel de produits laitiers. (3 pts)
3. Si l'association refuse les contreparties de l'industriel et que celui-ci retire son financement, de combien faut-il réduire le budget ou trouver d'autres financements ? Proposez deux solutions. (2 pts)
4. Rédigez quatre clauses d'une convention de partenariat qui protège l'indépendance de l'association. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.28 – Le Code international des substituts du lait maternel (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez avec une puéricultrice d'un centre de protection maternelle et infantile (fictif) un atelier « alimentation des tout-petits » pour des parents d'enfants de 0 à 3 ans.

Document 1 – Cinq propositions reçues

a) Un fabricant de laits infantiles propose des échantillons gratuits et des bons de réduction pour les parents.

b) Le même fabricant propose un « livret de diversification » illustré, avec son logo et ses petits pots.

c) Un laboratoire propose de financer le repas d'une soirée de formation pour l'équipe de la PMI.

d) Une association de soutien à l'allaitement propose d'animer un temps d'échange.

e) Une pharmacie voisine propose de prêter un tire-lait de démonstration.

À vous de jouer – Questions

1. Présentez en trois phrases l'objectif et les principales règles du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (OMS, 1981). (3 pts)
2. Analysez chaque proposition du document 1 et indiquez votre décision. (6 pts)
3. Comment parler des laits infantiles aux parents qui n'allaitent pas, sans les culpabiliser et sans faire de publicité ? (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.29 – Lire une déclaration d'intérêts (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une ville (fictive) organise une conférence publique sur « le sucre, vrai ou faux ? ». L'intervenant pressenti, un médecin nutritionniste, a rempli une déclaration de liens d'intérêts à la demande de la ville.

Document 1 – Extrait de la déclaration (données fictives)

- Trois conférences rémunérées par un fabricant de confiseries au cours des trois dernières années, 1 500 € chacune.
- Quatre repas offerts par le même fabricant, d'une valeur de 45 € chacun.
- Un déplacement à un congrès payé par le fabricant : 620 €.
- Membre du conseil scientifique d'une association de patients diabétiques (bénévole).
- Auteur d'un livre grand public sur l'alimentation.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le montant total des avantages reçus du fabricant. (2 pts)

2. Dites quels liens sont pertinents pour cette conférence et pourquoi. (3 pts)

3. Le médecin doit-il être écarté ? Présentez deux options et leurs conséquences. (4 pts)

4. Rédigez la phrase de transparence projetée au début de la conférence. (2 pts)

5. Où un citoyen peut-il vérifier les liens entre industries de santé et professionnels de santé ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.30 – Le forum santé des seniors (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre communal d'action sociale (CCAS) d'une ville (fictive) organise un forum « Bien vieillir » pour 400 seniors. Le budget est de 3 200 € ; les exposants paient 150 € leur stand. Vous êtes chargée de sélectionner les stands « alimentation ».

Document 1 – Six candidatures (données fictives)

a) Un fabricant de compléments alimentaires « mémoire et articulations », qui vendrait sur place.

b) Une mutuelle qui présente ses ateliers de prévention et ses contrats.

c) Une diététicienne libérale de la ville, qui propose un quiz et des recettes.

d) Un « nutritionniste » qui vend un programme de jeûne pour seniors.

e) Un supermarché qui propose une dégustation de ses produits allégés de marque propre.

f) Le service de portage de repas du CCAS.

Six exposants payants sont prévus au total, dont ces quatre : a), b), d), e).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part des droits de stand de six exposants dans le budget, puis la part des quatre exposants a), b), d), e). (2 pts)
2. Construisez une grille de sélection en quatre critères pour les stands « alimentation ». (3 pts)
3. Appliquez la grille aux six candidatures et donnez votre décision. (6 pts)
4. Proposez deux stands supplémentaires sans lien commercial, utiles à ce public. (2 pts)
5. Rédigez la réponse au fabricant de compléments. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 6.25

1. Légendes : 1 Identifier ; 2 qui finance, qui gagne quoi ? ; 3 Déclarer ; 4 par écrit, à la structure et au public ; 5 Évaluer ; 6 risque pour l'indépendance des messages ? ; 7 Encadrer ou refuser ; 8 convention écrite, sans logo ni produit ; ou refus motivé ; 9 Rendre transparent ; 10 mention du soutien, contenus décidés par le professionnel.
2. Le conflit d'intérêts est une situation où un intérêt secondaire peut influencer, ou paraître influencer, le jugement du professionnel au détriment de la santé des personnes. Le lien d'intérêts est simplement l'existence d'une relation (financement, emploi, amitié) ; il devient un conflit quand il touche le sujet traité et qu'il n'est ni déclaré ni géré.
3. Exemple : la diététicienne qui anime un atelier municipal est la sœur du gérant d'une épicerie bio du quartier et recommande cette épicerie ; ou elle anime un atelier sur un sujet où elle a écrit un livre qu'elle souhaite vendre.

Corrigé – Exercice 6.26

1. Légendes : 1 Acceptable ; 2 subvention publique ; prêt de salle ; dons de denrées sans marque ni logo ; supports de Santé publique France ; 3 À encadrer ; 4 bon d'achat d'un commerce local ; mécénat d'une entreprise ; supports d'une interprofession à vérifier ; 5 À refuser ; 6 échantillons de lait infantile ; logo d'une marque sur une campagne de santé ; collecte de données des participants ; vente de produits.
2. Vert : a) financement public ; c) don de produits bruts sans marque ; h) outils institutionnels. Orange : d) fiches à vérifier (exactitude, neutralité, absence de promotion) ; f) mécénat sans contrepartie, à formaliser par une convention. Rouge : b) logo d'une marque de sodas sur un objet de santé distribué aux élèves ; e) logo d'une enseigne de restauration rapide sur une campagne de santé ; g) collecte de données de mineurs en échange d'un service.
3. Pour d) : vérifier les sources et les dates, l'absence de message publicitaire, et citer l'interprofession comme auteur ; pour f) : convention écrite, aucun droit de regard sur les contenus, mention sobre du soutien.

Corrigé – Exercice 6.27

1. Ville : 2 000 / 4 800 = **41,7 %** ; CAF : 1 200 / 4 800 = **25,0 %** ; industriel : 1 000 / 4 800 = **20,8 %** ; fondation : 600 / 4 800 = **12,5 %**. Financement privé : (1 000 + 600) / 4 800 = **33,3 %**.
2. Le logo sur les supports associe l'association à une marque ; la présentation des produits pendant un atelier est une promotion commerciale auprès d'un public qui fait confiance à l'association ; les messages sur les produits laitiers risquent d'être orientés ; l'association devient dépendante d'un financement qui représente un cinquième du budget.
3. Il manque **1 000 €** (20,8 % du budget). Solutions : réduire le nombre d'ateliers ou le matériel ; solliciter un autre financeur public (appel à projets de l'agence régionale de santé, conférence des financeurs, département) ; demander à la fondation un soutien plus important, sans contrepartie publicitaire.
4. Clauses : « Le contenu des ateliers et des supports est décidé par l'association seule » ; « Aucun produit de marque n'est présenté, distribué ou promu » ; « Le soutien est mentionné de façon sobre, sans logo sur les supports de prévention » ; « L'association peut mettre fin à la convention si une clause n'est pas respectée » ; « Aucune donnée des participants n'est transmise au partenaire ».

Corrigé – Exercice 6.28

1. Le Code, adopté par l'Assemblée mondiale de la santé en 1981, vise à protéger l'allaitement et à garantir un usage correct des substituts quand ils sont nécessaires. Il interdit la promotion de ces produits auprès du public, la distribution d'échantillons gratuits aux mères et les cadeaux aux mères ; l'information des

professionnels doit être scientifique et factuelle.

2. a) Refus : échantillons et bons de réduction sont expressément contraires au Code. b) Refus : support promotionnel déguisé en outil éducatif ; utiliser plutôt les documents de Santé publique France et du programme des 1 000 premiers jours. c) Refus : avantage offert aux professionnels qui crée un lien d'intérêts avec l'équipe. d) Accepté, en vérifiant que le temps d'échange respecte aussi les parents qui n'allaitent pas. e) Accepté si le prêt n'est associé à aucune promotion de produits ou de marques ; à défaut, présenter le matériel avec des photos.

3. Partir des besoins des parents, sans jugement sur leur choix ; donner des informations pratiques et neutres (préparation des biberons, hygiène, quantités, signes de faim et de satiété) sans citer de marque ; rappeler que tous les laits infantiles vendus en France répondent à la même réglementation et qu'il n'est pas utile de choisir les plus chers ; orienter vers le médecin ou la PMI pour les questions individuelles.

Corrigé – Exercice 6.29

1. Conférences : 3 × 1 500 = 4 500 € ; repas : 4 × 45 = 180 € ; déplacement : 620 € ; total : **5 300 €** reçus du fabricant de confiseries.

2. Pertinents : les liens avec le fabricant de confiseries (sujet de la conférence : le sucre) ; le livre grand public (intérêt personnel possible à sa promotion). Le rôle bénévole dans une association de patients diabétiques est un lien non financier, à mentionner par transparence, mais il ne crée pas de conflit sur ce sujet.

3. Option 1 : choisir un autre intervenant sans lien avec l'industrie sucrière ; avantage : crédibilité de la conférence ; inconvénient : il faut trouver un autre spécialiste. Option 2 : maintenir l'intervenant, avec déclaration publique de ses liens, contenu fondé sur les recommandations officielles (OMS 2015, Santé publique France 2019) et un second intervenant indépendant ; avantage : expertise reconnue ; inconvénient : le public peut douter de l'indépendance. Sur un sujet aussi directement lié au fabricant, l'option 1 est préférable.

4. Exemple : « Liens d'intérêts : au cours des trois dernières années, j'ai été rémunéré par un fabricant de confiseries pour trois conférences et j'ai bénéficié d'avantages (repas, déplacement). Je suis l'auteur d'un livre sur l'alimentation. Les informations présentées ce soir s'appuient sur les recommandations de l'OMS et de Santé publique France. »

5. Sur la base publique Transparence Santé (transparence.sante.gouv.fr).

Corrigé – Exercice 6.30

1. Six stands : 6 × 150 = 900 €, soit 900 / 3 200 = **28,1 %** du budget ; quatre stands a), b), d), e) : 4 × 150 = 600 €, soit 600 / 3 200 = **18,8 %**.

2. Grille : (1) l'intervenant est qualifié (titre protégé, compétence reconnue) ; (2) les messages sont fondés sur des preuves et compatibles avec les recommandations officielles ; (3) aucune vente ni prise de commande sur place et aucune collecte de données à des fins commerciales ; (4) le stand ne présente pas de risque pour les seniors (restriction, dénutrition, dépenses inutiles).

3. a) Refus : vente sur place de compléments aux allégations à vérifier, public âgé exposé à des dépenses inutiles. b) Acceptable si le stand présente les ateliers de prévention sans démarchage commercial pour les contrats. c) Accepté : professionnelle qualifiée ; elle ne doit pas faire la promotion de son cabinet, et l'on peut proposer une liste de plusieurs professionnels. d) Refus : titre non protégé, jeûne déconseillé chez les seniors exposés à la dénutrition, vente d'un programme. e) Refus en l'état : promotion de produits de marque ; possible sous la forme d'une dégustation de fruits de saison sans marque. f) Accepté : service public utile au maintien à domicile.

4. Exemples : stand « Bien manger pour rester en forme » animé par une diététicienne de la conférence des financeurs ou du CCAS (dénutrition, protéines, plaisir) ; stand des associations de jardins partagés ou des épiceries solidaires ; atelier « hydratation et canicule » ; stand de l'activité physique adaptée.

5. Exemple : « Madame, Monsieur, nous vous remercions de votre proposition. Le forum "Bien vieillir" est un événement de prévention organisé par un service public, et nous avons choisi de n'y accueillir aucune vente de produits de santé. Nous ne pouvons donc pas retenir votre candidature. Nous vous prions d'agréer nos salutations distinguées. »

Partie 6 – Allégations, publicité et compléments alimentaires

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer allégation nutritionnelle, allégation de santé et allégation interdite.
- Vérifier une allégation nutritionnelle à partir d'un étiquetage, par le calcul.
- Connaître l'encadrement de la publicité alimentaire et des messages sanitaires.
- Conseiller une personne qui achète un complément alimentaire et savoir faire un signalement de nutrivigilance.
- Analyser une publication d'influenceur au regard de la loi du 9 juin 2023.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Règlement (CE) n° 1924/2006 : seules les allégations figurant sur les listes autorisées et respectant leurs conditions sont permises.
- « Source de fibres » : au moins 3 g pour 100 g ou 1,5 g pour 100 kcal. « Riche en fibres » : au moins 6 g pour 100 g ou 3 g pour 100 kcal.
- « Source de protéines » : au moins 12 % de l'énergie apportée par les protéines. « Riche en protéines » : au moins 20 %.
- « Faible teneur en sucres » : 5 g au plus pour 100 g (2,5 g pour 100 mL pour un liquide). « Sans sucres » : 0,5 g au plus pour 100 g ou 100 mL.
- « Pauvre en sodium ou en sel » : 0,12 g de sodium au plus pour 100 g. « Très pauvre » : 0,04 g. 1 g de sodium correspond à 2,5 g de sel.
- Un aliment ne peut jamais prétendre prévenir, traiter ou guérir une maladie (règlement (UE) n° 1169/2011, article 7).
- Compléments alimentaires : décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ; déclaration avant mise sur le marché ; nutrivigilance confiée à l'Anses depuis la loi du 21 juillet 2009.
- Influence commerciale : loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 ; mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale » obligatoire.

Exercice 6.31 – Les types d'allégations (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un atelier « lire les emballages » pour un groupe de parents d'une maison de quartier (fictive). Vous préparez un support qui résume ce qu'un fabricant a le droit d'écrire.

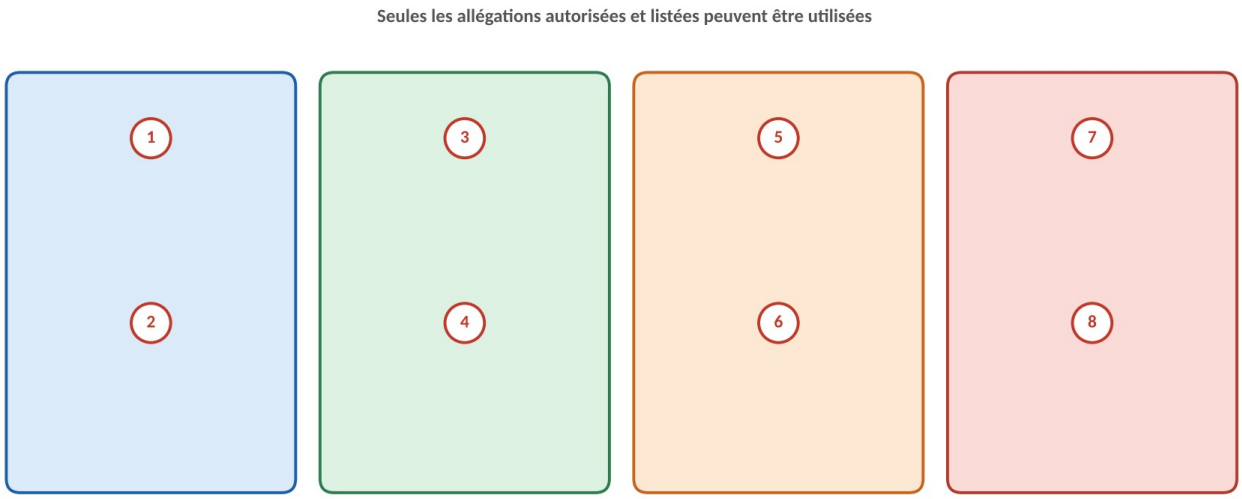


Figure 6.9 – Document 1 – Les types d'allégations (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Définissez une allégation au sens du règlement (CE) n° 1924/2006. (2 pts)
3. Donnez un exemple d'allégation nutritionnelle et un exemple d'allégation de santé fonctionnelle. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi une allégation non autorisée pose un problème éthique et pas seulement juridique. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.32 – Trier dix mentions d'emballage (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pendant l'atelier, les parents ont relevé dix mentions sur des emballages. Ils vous demandent si elles sont permises.

Document 1 – Dix mentions relevées (produits fictifs)

a) « Riche en vitamine C » sur un jus d'orange.

b) « Le calcium est nécessaire au maintien d'une ossature normale » sur un fromage blanc.

c) « Guérit la constipation » sur un pain aux céréales.

d) « Perdez 5 kg en 3 semaines » sur une boisson.

e) « Sans sucres ajoutés » sur une compote.

f) « Brûleur de graisse naturel » sur un thé aromatisé.

g) « Recommandé par les nutritionnistes » sur des biscuits, sans autre précision.

h) « Allégé en matières grasses » sur une margarine.

i) « Booste l'immunité » sur une boisson lactée, sans référence à un nutriment.

j) « Source de fibres » sur des céréales.

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque mention : allégation nutritionnelle, allégation de santé, allégation interdite ou mention à vérifier. Justifiez en une phrase. (6 pts)
2. Pour deux mentions à vérifier, indiquez l'information de l'étiquetage qu'il faut lire. (2 pts)
3. Indiquez à quel organisme un consommateur peut signaler une mention trompeuse. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.33 – Vérifier une allégation par le calcul (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calculs et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une épicerie solidaire (fictive) veut mettre en avant des produits « intéressants pour la santé ». Elle vous demande de vérifier les allégations de cinq produits avant de faire une affiche.

Document 1 – Étiquetage nutritionnel pour 100 g ou 100 mL (produits fictifs)

Produit	Énergie (kcal)	Fibres (g)	Protéines (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Sel (g)	Allégations sur l'emballage
Biscuit A	452	6,4	7,5	22	16	0,55	« Riche en fibres »
Céréales B	372	4,1	11,8	4,6	2,4	0,28	« Source de fibres », « source de protéines », « pauvre en sel », « faible teneur en sucres »
Galettes C	387	3,6	8,2	0,4	2,8	0,02	« Riche en fibres », « sans sucres », « très pauvre en sel »
Boisson D (100 mL)	46	0	3,4	4,9	1,5	0,10	« Riche en protéines », « faible teneur en sucres », « faible teneur en matières grasses »
Barre E	398	8,0	21,0	18,0	12,0	0,30	« Riche en protéines », « riche en fibres », « brûle les graisses »

Document 2 – Seuils utiles

« Faible teneur en matières grasses » : 3 g au plus pour 100 g (1,5 g pour 100 mL pour un liquide). Les autres seuils sont dans l'encadré « À connaître par cœur ». 1 g de protéines apporte 4 kcal.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque produit, calculez les fibres pour 100 kcal, la part de l'énergie apportée par les protéines et la teneur en sodium. (5 pts)
2. Indiquez, pour chaque allégation, si elle est conforme. Justifiez par un chiffre. (6 pts)
3. Le biscuit A est « riche en fibres ». Expliquez pourquoi l'épicerie ne doit pas pour autant le présenter comme un produit « santé ». (2 pts)
4. Proposez la phrase de l'affiche pour les galettes C. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.34 – Publicité alimentaire et messages sanitaires (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un lycée (fictif) a interrogé 240 élèves sur les publicités alimentaires vues sur les écrans. Vous intervenez en éducation morale et civique avec l'infirmière.

Document 1 – Résultats de l'enquête (données fictives, 2027)

- 168 élèves déclarent avoir vu, la semaine précédente, au moins une publicité pour un produit gras, sucré ou salé accompagnée d'un message sanitaire.
- Parmi ces 168 élèves, 71 pensent que le message sanitaire « veut dire que le produit est bon pour la santé ».
- Parmi ces 168 élèves, 38 déclarent avoir acheté le produit dans la semaine.

Document 2 – Le cadre (sources datées)

Depuis l'arrêté du 27 février 2007 (application de la loi du 9 août 2004), les publicités pour des aliments et boissons avec ajout de sucres, de sel ou d'édulcorants doivent porter un message sanitaire, par exemple « Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour », avec l'adresse www.mangerbouger.fr. L'annonceur peut s'y soustraire en versant une contribution de 1,5 % du montant de ses achats d'espace à Santé publique France. La loi du 20 décembre 2016 a supprimé la publicité commerciale dans les programmes pour enfants de la télévision publique depuis le 1er janvier 2018.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part des élèves exposés, la part des élèves exposés qui se trompent sur le sens du message, et la part des élèves exposés qui ont acheté. (3 pts)
2. Analysez les limites du message sanitaire mises en évidence par l'enquête. (3 pts)
3. Expliquez en quoi la publicité ciblant les jeunes pose une question d'éthique (principes de bienfaisance et d'autonomie). (3 pts)
4. Proposez deux activités pour développer l'esprit critique des élèves face à la publicité. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.35 – Le complément « minceur détox » (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – conseil · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Mme R., 46 ans, suivie au centre de santé où vous effectuez votre stage, vous montre un complément alimentaire commandé sur internet. Elle en prend depuis trois semaines et se plaint de palpitations et de troubles du sommeil.

Document 1 – Extrait de l'emballage (produit fictif)

« SlimDétox+ : brûle les graisses, élimine les toxines, coupe la faim. Extrait de thé vert, guarana, garcinia, café vert. 3 gélules par jour. Boîte de 60 gélules : 29,90 €. Fabriqué hors de l'Union européenne. »

Document 2 – Le cadre (sources datées)

Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires (décret n° 2006-352 du 20 mars 2006). Ils sont déclarés à l'administration avant leur mise sur le marché, mais ils ne font pas l'objet d'une autorisation comme un médicament. Depuis 2009, l'Anses gère un dispositif de nutrivigilance : les professionnels de santé déclarent les effets indésirables suspectés en ligne sur le portail des signalements du ministère de la santé.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la durée d'une boîte, le coût pour 30 jours et le coût pour un an. (2 pts)
2. Relevez les allégations du document 1 et dites si elles sont permises. (3 pts)
3. Expliquez le lien possible entre les ingrédients et les symptômes de Mme R. (2 pts)
4. Rédigez ce que vous dites à Mme R., avec respect et sans jugement. (3 pts)
5. Indiquez ce que l'équipe doit faire au titre de la nutrivigilance, et les informations à transmettre. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.36 – Une publication d'influenceur (14 points)

★★★★★ *Niveau 5 – analyse critique · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un groupe d'étudiants en BTS Diététique et Nutrition anime un compte de prévention sur un réseau social. Une marque de compléments leur propose une collaboration. Ils vous montrent la publication d'un influenceur qui travaille déjà avec cette marque.

Document 1 – Publication d'un influenceur (fictive)

« Mes abonnés me demandent tout le temps comment je reste sec toute l'année. Mon secret : les gélules ShapeFast, 2 le matin et je ne mange plus rien jusqu'à 16 h ! J'ai perdu 6 kg en un mois sans effort. Code promo LEO20 pour -20 %. Pas besoin d'aller voir un médecin, la nature fait tout. #santé #minceur #nutrition » (photo retouchée, aucune mention commerciale)

Document 2 – Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 (extraits résumés)

L'influenceur doit indiquer clairement « Publicité » ou « Collaboration commerciale » pendant toute la durée du contenu. Une image retouchée ou produite par intelligence artificielle doit porter la mention « Image retouchée » ou « Image virtuelle ». La promotion de l'abstention thérapeutique et celle des actes de chirurgie esthétique sont interdites. Les pratiques commerciales trompeuses sont sanctionnées ; la DGCCRF contrôle.

À vous de jouer – Questions

1. Relevez quatre manquements à la loi du 9 juin 2023 ou aux règles sur les allégations dans le document 1. (4 pts)
2. Identifiez les risques pour la santé des abonnés. (3 pts)
3. Les étudiants doivent-ils accepter la collaboration proposée ? Argumentez en vous appuyant sur les conflits d'intérêts (partie 5) et sur les principes éthiques. (4 pts)
4. Rédigez une courte publication de prévention qui répond au document 1 sans viser l'influenceur personnellement. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 6.31

1. (1) Nutritionnelle ; (2) « riche en fibres » : au moins 6 g pour 100 g ou 3 g pour 100 kcal ; (3) De santé fonctionnelle ; (4) rôle d'un nutriment sur une fonction (article 13), liste autorisée ; (5) Réduction d'un risque de maladie ; (6) autorisée au cas par cas après avis de l'EFSA (article 14) ; (7) Interdite ; (8) guérir ou traiter une maladie ; promettre une perte de poids chiffrée ; « brûleur de graisse ».
2. Une allégation est tout message ou représentation, non obligatoire, qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée possède des caractéristiques particulières (texte, image, symbole, nom de marque).
3. Nutritionnelle : « source de fibres ». Santé fonctionnelle : « le calcium est nécessaire au maintien d'une ossature normale ».
4. Elle trompe le consommateur, donc elle porte atteinte à son autonomie (il choisit sur une information fausse) et peut lui nuire (non-malfaisance), surtout chez les personnes vulnérables ou malades.

Corrigé – Exercice 6.32

1. a) Nutritionnelle, à vérifier : pour une boisson, il faut au moins 15 % de la valeur nutritionnelle de référence pour 100 mL (le double du seuil de « source »). b) Santé fonctionnelle autorisée si le fromage blanc est au moins « source de calcium ». c) Interdite : un aliment ne peut prétendre guérir une maladie. d) Interdite : perte de poids chiffrée. e) Nutritionnelle, à vérifier : aucun sucre ni aucun ingrédient sucrant n'a été ajouté (la mention « contient des sucres naturellement présents » s'impose si besoin). f) Interdite : promesse non autorisée et trompeuse. g) Interdite en l'état : une recommandation n'est possible que de la part d'associations nationales de professionnels de la médecine, de la nutrition ou de la diététique, ou d'organisations caritatives de santé ; une mention vague est trompeuse. h) Nutritionnelle, à vérifier : réduction d'au moins 30 % par rapport à un produit similaire. i) Interdite en l'état : allégation de santé générale sans allégation autorisée qui l'accompagne. j) Nutritionnelle, à vérifier : au moins 3 g pour 100 g ou 1,5 g pour 100 kcal.
2. Exemples : pour a), la teneur en vitamine C et le pourcentage de la valeur nutritionnelle de référence ; pour j), la teneur en fibres et l'énergie pour 100 g ; pour h), la teneur en lipides et celle du produit de référence.
3. La DGCCRF (plateforme SignalConso) ; la direction départementale de la protection des populations (DDPP) mène les contrôles.

Corrigé – Exercice 6.33

1. Fibres pour 100 kcal : A 1,42 g ; B 1,10 g ; C 0,93 g ; D 0 ; E 2,01 g. Part de l'énergie des protéines (protéines × 4 / énergie) : A 6,6 % ; B 12,7 % ; C 8,5 % ; D 29,6 % ; E 21,1 %. Sodium (sel / 2,5) : A 0,220 g ; B 0,112 g ; C 0,008 g ; D 0,040 g ; E 0,120 g.
2. A « riche en fibres » : conforme (6,4 g ≥ 6 g pour 100 g). B « source de fibres » : conforme (4,1 g ≥ 3 g) ; « source de protéines » : conforme (12,7 % ≥ 12 %) ; « pauvre en sel » : conforme (0,112 g ≤ 0,12 g de sodium) ; « faible teneur en sucres » : conforme (4,6 g ≤ 5 g). C « riche en fibres » : non conforme (3,6 g < 6 g et 0,93 g < 3 g pour 100 kcal) ; seule « source de fibres » est possible (3,6 g ≥ 3 g) ; « sans sucres » : conforme (0,4 g ≤ 0,5 g) ; « très pauvre en sel » : conforme (0,008 g ≤ 0,04 g). D « riche en protéines » : conforme (29,6 % ≥ 20 %) ; « faible teneur en sucres » : non conforme (4,9 g > 2,5 g pour 100 mL) ; « faible teneur en matières grasses » : conforme, à la limite (1,5 g ≤ 1,5 g). E « riche en protéines » : conforme (21,1 % ≥ 20 %) ; « riche en fibres » : conforme (8,0 g ≥ 6 g) ; « brûle les graisses » : interdite.
3. Une allégation porte sur un seul nutriment. Le biscuit A reste riche en sucres (22 g) et en lipides (16 g) et très énergétique (452 kcal) : c'est un produit à consommer occasionnellement. Le Nutri-Score et la liste des ingrédients donnent une vue plus complète.
4. Exemple : « Galettes C : sans sucres, très pauvres en sel et source de fibres. »

Corrigé – Exercice 6.34

1. Exposés : 168 / 240 = **70,0 %**. Erreur sur le sens du message : 71 / 168 = **42,3 %**. Achat : 38 / 168 = **22,6 %** des élèves exposés (15,8 % de l'ensemble des élèves).
2. Le message est mal compris par plus de quatre élèves exposés sur dix : il peut même servir d'argument de vente. Il n'empêche pas l'achat (près d'un exposé sur quatre). Il est générique, sans lien avec le produit, et l'annonceur peut s'en dispenser en payant une contribution. Les données sont déclaratives et fictives : l'enquête ne prouve pas que la publicité cause l'achat.
3. Bienfaisance : les jeunes sont exposés à des produits dont l'excès nuit à leur santé, la société a le devoir de les protéger. Autonomie : les mineurs ont moins de recul face aux techniques de persuasion ; une publicité qui exploite leur crédulité réduit leur liberté de choix au lieu de l'éclairer.
4. Exemples : décrypter des publicités en groupe (cible, procédés, message caché) ; comparer l'image du produit et sa composition réelle ; créer une « contre-publicité » pour un aliment simple ; tenir un journal des publicités vues pendant une semaine.

Corrigé – Exercice 6.35

1. Une boîte dure 60 / 3 = **20 jours**. Coût pour 30 jours : 29,90 / 20 × 30 = **44,85 €**. Coût pour un an : 29,90 / 20 × 365 = **545,68 €**.
2. « Brûle les graisses » et « élimine les toxines » : interdites, non autorisées et trompeuses. « Coupe la faim » : non autorisée pour ces ingrédients, donc interdite.
3. Le thé vert, le guarana et le café vert apportent de la caféine. L'addition des sources et des doses peut provoquer palpitations, nervosité et insomnie. La fabrication hors de l'Union européenne et l'achat en ligne augmentent le risque de composition non conforme.
4. Exemple : « Merci de m'en avoir parlé. Les symptômes que vous décrivez peuvent être liés à la caféine contenue dans ce produit. Je vous conseille de l'arrêter et d'en parler au médecin aujourd'hui. Ce produit n'a pas prouvé qu'il fait maigrir. Si vous le souhaitez, nous pouvons voir ensemble ce qui est important pour vous et construire des objectifs réalistes. »
5. Le médecin ou le professionnel de santé déclare l'effet indésirable suspecté (portail des signalements, nutrivigilance de l'Anses). Informations : âge et sexe, nom exact du produit, lot, doses et durée, autres produits et médicaments, nature, date et évolution des symptômes ; garder l'emballage. Les données sont transmises avec l'accord de Mme R. et de façon sécurisée.

Corrigé – Exercice 6.36

1. Absence de mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale » malgré un code promo ; photo retouchée sans la mention « Image retouchée » ; promotion de l'abstention thérapeutique (« pas besoin d'aller voir un médecin ») ; perte de poids chiffrée (6 kg en un mois) et promesse « sans effort », allégations interdites.
2. Restriction alimentaire prolongée (jeûne jusqu'à 16 h), risque de troubles du comportement alimentaire chez des abonnés jeunes, effets indésirables possibles des gélules, retard au diagnostic d'un problème de santé, dépenses inutiles, culpabilité.
3. Non. Accepter créerait un lien d'intérêts financier avec une marque dont les messages contredisent les recommandations ; le public ne pourrait plus faire confiance aux contenus de prévention. Les principes de non-malfaisance (ne pas promouvoir un produit à risque), de bienfaisance et d'autonomie (information loyale) conduisent à refuser. Une réponse polie et motivée est envoyée, et le compte peut annoncer sa politique : aucun partenariat commercial.
4. Exemple : « Vous voyez passer des gélules "minceur" qui promettent des kilos perdus sans effort ? Aucune gélule ne fait maigrir de façon durable, et certaines provoquent palpitations ou insomnie. Sauter des repas peut entraîner fatigue et grignotage. Pour être en forme : des repas réguliers, des fruits, des légumes et des légumineuses, de l'activité physique qui vous plaît. En cas de question, parlez-en à votre

> médecin ou à un(e) diététicien(ne). Sources : Santé publique France, mangerbouger.fr (consulté en octobre 2026). »

Partie 7 – Enquêtes, recherche et identité numérique

Objectifs – Objectifs de la partie

- Classer un projet d'enquête ou de recherche et en déduire les règles à suivre.
- Rédiger une note d'information conforme au RGPD.
- Calculer un taux de participation et discuter les biais de non-réponse.
- Gérer son identité numérique personnelle et professionnelle.
- Utiliser une intelligence artificielle générative de façon responsable.
- Répondre à un avis négatif en ligne sans rompre le secret professionnel.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Loi Jardé (loi du 5 mars 2012, appliquée depuis novembre 2016) : une recherche sur la personne humaine demande un protocole, l'avis favorable d'un comité de protection des personnes (CPP) et le consentement ou la non-opposition des participants.
- Une enquête de diagnostic ou d'évaluation d'une action n'est pas une recherche sur la personne, mais elle reste soumise au RGPD.
- Note d'information : responsable, finalité, base légale, données collectées, destinataires, durée de conservation, droits et contact.
- Identité numérique : ce que je publie, ce que les autres publient sur moi, et les traces techniques.
- Règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle : entré en vigueur le 1er août 2024 ; interdictions depuis le 2 février 2025, transparence depuis le 2 août 2026, obligations des systèmes à haut risque reportées au 2 décembre 2027 et au 2 août 2028 (règlement (UE) 2026/1744).
- Ne jamais saisir de données de santé identifiantes dans un outil d'IA grand public.

Exercice 6.37 – Enquête ou recherche ? (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de diététique d'un centre hospitalier (fictif) a six projets pour l'année. La cadre vous demande de préparer un tableau des démarches.

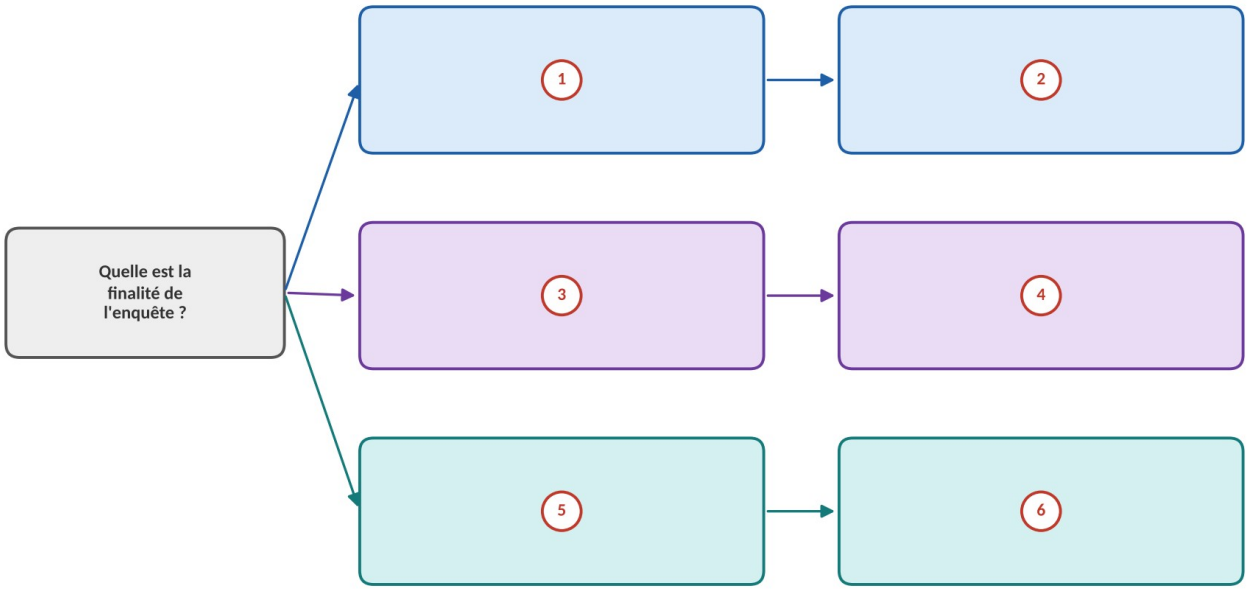


Figure 6.10 – Document 1 – Enquête, recherche ou étude sur données (schéma à légender)

Document 2 – Six projets

a) Questionnaire de satisfaction des patients sur les repas.

b) Essai comparant deux compléments nutritionnels oraux, avec prise de sang avant et après.

c) Relecture de 300 dossiers pour connaître la fréquence de la dénutrition à l'entrée.

d) Évaluation d'un atelier d'éducation thérapeutique par un questionnaire avant et après.

e) Mesure de la force de préhension et de la composition corporelle pour étudier le lien avec la durée de séjour.

f) Analyse des données du logiciel de commande des repas pour réduire le gaspillage.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Classez les six projets du document 2 dans l'une des trois catégories du document 1. (4 pts)
3. Pour le projet b), citez trois obligations avant de commencer. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.38 – Rédiger une note d'information (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – rédaction · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de restauration scolaire d'une commune (fictive) veut interroger les parents des élèves de trois écoles sur les goûters. Le questionnaire est papier, sans nom. Il demande l'âge et le sexe de l'enfant, l'école, la classe, les aliments du goûter et d'éventuelles allergies.

Document 1 – Projet de note rédigé par un stagiaire

« Chers parents, merci de remplir ce questionnaire. C'est obligatoire. Vos réponses seront utilisées par la mairie et nos partenaires. Merci ! »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez trois défauts du document 1. (3 pts)

2. Rédigez une note d'information complète et lisible (10 à 12 lignes). (5 pts)

3. La question sur les allergies est-elle nécessaire ? Justifiez au regard du principe de minimisation. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.39 – Taux de participation et biais (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calculs et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'enquête de l'exercice 6.38 a été réalisée. Vous exploitez les retours.

Document 1 – Bilan de la collecte (données fictives, 2027)

École	Questionnaires distribués	Questionnaires rendus
Les Tilleuls	140	112
Jean-Zay	150	96
Du Port	130	65
Total	**420**	**273**

Parmi les 273 questionnaires rendus, 12 portent la case cochée « je ne souhaite pas que mes réponses soient utilisées » et 9 sont trop incomplets pour être exploités.

L'école du Port est située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de retour global et par école. (3 pts)
2. Calculez le nombre de questionnaires exploitables et leur part parmi les questionnaires distribués et parmi les questionnaires rendus. (3 pts)
3. Que faites-vous des 12 questionnaires avec opposition ? Justifiez. (2 pts)
4. Analysez le risque de biais lié à la faible participation de l'école du Port et proposez deux moyens de le réduire. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.40 – Mon identité numérique (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Léa, étudiante en BTS Diététique et Nutrition, cherche un stage. Elle tape son nom dans un moteur de recherche et trouve : une photo de soirée publiée par une amie, son compte personnel public où elle commente des régimes, une vidéo « Ma journée en stage à l'hôpital » où l'on voit le badge d'un patient, et son profil professionnel à jour.

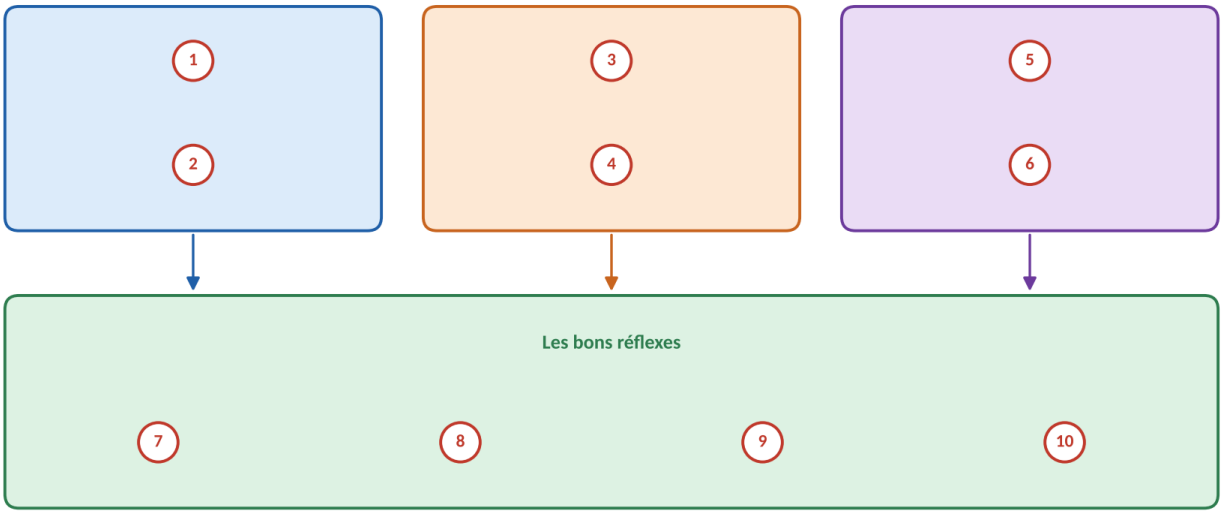


Figure 6.11 – Document 1 – Mon identité numérique (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (5 pts)
2. Classez les quatre éléments trouvés par Léa dans les trois cercles de l'identité numérique. (2 pts)
3. Indiquez le problème le plus grave et ce que Léa doit faire tout de suite. (2 pts)
4. Donnez un conseil pour son compte personnel. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.41 – L'intelligence artificielle au service du diététicien (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – analyse critique · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un collègue de stage a utilisé un outil d'intelligence artificielle générative grand public pour préparer une consultation. Il vous montre ce qu'il a saisi et la réponse obtenue.

Document 1 – Saisie et réponse (fictives)

Saisie : « Inès Belkacem, née le 3 mars 2012, 15 ans, 1,62 m, 68 kg, diabète de type 1, suivie au CH de Vallière. Fais-lui un menu pour maigrir. »

Réponse : « Voici un menu à 1 200 kcal par jour pour une perte de poids rapide : petit déjeuner : café noir ; déjeuner : salade verte et blanc de poulet ; dîner : soupe de légumes. Supprimez le pain, les féculents et les fruits, qui font monter la glycémie. Source : étude de Harvard, 2021. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez les problèmes liés à la saisie (protection des données et secret professionnel). (3 pts)
2. Relevez les erreurs et les dangers de la réponse pour cette adolescente. (4 pts)
3. Énoncez quatre règles d'usage responsable de l'IA générative pour un professionnel de la nutrition. (4 pts)
4. Indiquez ce que le collègue doit faire maintenant. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.42 – Répondre à un avis négatif en ligne (14 points)

★★★★★ *Niveau 5 – communication éthique · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne libérale (fictive) chez qui vous êtes en stage reçoit un avis public sur sa fiche d'établissement. Elle est blessée et veut répondre le soir même.

Document 1 – L'avis (fictif)

« Une étoile. Consultation inutile : elle m'a juste dit de manger moins de gâteaux alors que j'ai un problème de thyroïde. 50 euros pour rien. À fuir. » – K.M.

Document 2 – Brouillon de réponse de la diététicienne

« Madame M., je me souviens très bien de vous. Votre bilan montrait une consommation excessive de produits sucrés, et votre hypothyroïdie est traitée depuis des années, je l'ai noté dans votre dossier. Vous n'avez pas suivi mes conseils, ce n'est pas ma faute. »

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi le brouillon du document 2 viole le secret professionnel, même si la patiente a parlé la première. (3 pts)
2. Relevez les autres défauts du brouillon (ton, posture professionnelle). (2 pts)
3. Rédigez une réponse publique conforme (5 à 7 lignes). (4 pts)
4. Proposez deux actions hors ligne pour traiter la situation. (2 pts)
5. Indiquez dans quel cas la diététicienne pourrait demander le retrait de l'avis, et auprès de qui. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 6.37

1. (1) Diagnostic ou évaluation d'une action ; (2) RGPD : information, minimisation, anonymat ; registre de la structure ; (3) Recherche sur la personne (connaissances biologiques ou médicales) ; (4) loi Jardé (2012) : protocole, avis d'un CPP, consentement ou non-opposition ; (5) Étude sur des données existantes (dossiers, bases) ; (6) RGPD : méthodologie de référence MR-004 de la CNIL, information des personnes.
2. Diagnostic ou évaluation : a), d), f). Recherche sur la personne : b), e). Étude sur données existantes : c).
3. Rédiger un protocole ; obtenir l'avis favorable d'un CPP ; recueillir le consentement libre, éclairé et écrit des patients (recherche interventionnelle avec prélèvement) ; déclarer la conformité au RGPD et désigner un promoteur.

Corrigé – Exercice 6.38

1. Le questionnaire est présenté comme obligatoire alors que la participation doit être libre ; les destinataires (« nos partenaires ») sont vagues ; il manque la finalité, la durée de conservation, les droits et le contact.
2. Exemple : « Madame, Monsieur, le service de restauration scolaire de la commune souhaite mieux connaître les goûters des enfants afin de proposer des ateliers adaptés. Ce questionnaire est anonyme et facultatif : vous pouvez ne pas répondre ou cocher la case "je ne souhaite pas que mes réponses soient utilisées". Il recueille l'âge, le sexe, l'école et la classe de l'enfant, les aliments du goûter et les allergies. Les réponses sont saisies par le service de restauration et ne sont transmises à personne d'autre ; seuls des résultats globaux seront publiés. Les questionnaires papier seront détruits trois mois après la saisie, et le fichier dans un an. Responsable : la commune (service restauration). Pour toute question ou pour exercer vos droits : délégué à la protection des données de la mairie, [adresse]. Vous pouvez aussi saisir la CNIL. Merci de votre aide. »
3. Elle n'est utile que si les ateliers doivent adapter les goûters proposés. Sinon, elle est à supprimer (minimisation), d'autant qu'il s'agit d'une donnée de santé ; les allergies sont déjà connues par les projets d'accueil individualisé.

Corrigé – Exercice 6.39

1. Global : 273 / 420 = **65,0 %**. Les Tilleuls : 112 / 140 = **80,0 %** ; Jean-Zay : 96 / 150 = **64,0 %** ; du Port : 65 / 130 = **50,0 %**.
2. Exploitables : 273 − 12 − 9 = **252**, soit 252 / 420 = **60,0 %** des questionnaires distribués et 252 / 273 = **92,3 %** des questionnaires rendus.
3. Ils ne sont pas saisis et sont détruits : les parents ont exercé leur droit d'opposition, et l'on doit le respecter.
4. Les familles du quartier prioritaire sont sous-représentées ; or leurs goûters peuvent être différents (budget, habitudes). Les résultats risquent de décrire surtout les familles favorisées et de conduire à des ateliers inadaptés. Moyens : relance par les enseignants et le centre social, questionnaire traduit ou en pictogrammes, passation orale à la sortie de l'école avec un habitant relais, analyse des résultats séparée par école.

Corrigé – Exercice 6.40

1. (1) Ce que je publie ; (2) profils, photos, commentaires, vidéos ; (3) Ce que les autres publient sur moi ; (4) photos, avis, mentions, articles ; (5) Les traces techniques ; (6) historique, géolocalisation, données d'applications ; (7) comptes personnels et professionnels séparés ; (8) aucune photo de participant sans autorisation ; (9) contenus sourcés et datés ; (10) partenariat commercial toujours signalé.
2. Ce que je publie : le compte personnel public, la vidéo de stage, le profil professionnel. Ce que les autres

publient sur moi : la photo de soirée.

3. La vidéo de stage : on y voit le badge d'un patient, c'est une violation du secret professionnel et du droit à l'image. Léa doit la supprimer immédiatement et prévenir son tuteur de stage et son établissement de formation.

4. Passer son compte personnel en privé et éviter de commenter des régimes sous son nom : ses propos peuvent être pris pour des conseils professionnels.

Corrigé – Exercice 6.41

1. La saisie contient des données identifiantes (nom, date de naissance, établissement) et une donnée de santé (diabète de type 1). Elle les transmet à un service externe, sans base légale ni information de la patiente : c'est une violation du secret professionnel et du RGPD.

2. 1 200 kcal sont très insuffisantes pour une adolescente de 15 ans en croissance (risque de carences, de troubles du comportement alimentaire). Supprimer féculents et fruits chez une adolescente diabétique de type 1 traitée par insuline expose à des hypoglycémies graves et désorganise l'adaptation des doses. Le « petit déjeuner café noir » est inadapté. La source est vague et invérifiable, peut-être inventée. L'objectif « maigrir » n'a pas été discuté avec l'adolescente, sa famille et l'équipe de diabétologie.

3. Ne jamais saisir de données identifiantes ou de santé dans un outil grand public ; vérifier chaque information dans une source fiable et datée ; garder la décision et la responsabilité professionnelles ; être transparent avec les personnes et l'équipe sur l'usage de l'outil ; se méfier des biais et des références inventées ; suivre la charte de l'établissement.

4. Supprimer la conversation et l'historique si possible, ne pas utiliser la réponse, et signaler l'incident à son tuteur et au délégué à la protection des données de l'établissement.

Corrigé – Exercice 6.42

1. Le secret couvre tout ce que la professionnelle a appris dans l'exercice de son métier, y compris le fait même que la personne a consulté. Confirmer la consultation, citer le bilan et la pathologie, c'est révéler des informations de santé. Le fait que la patiente ait parlé la première ne délie pas la professionnelle du secret.

2. Ton agressif et culpabilisant (« ce n'est pas ma faute ») ; réponse sous le coup de l'émotion ; nom de la patiente cité ; mauvaise image pour la profession et pour les futurs patients.

3. Exemple : « Bonjour, merci d'avoir pris le temps de laisser un avis. Je suis tenue au secret professionnel et je ne peux donc ni confirmer ni commenter une consultation. Je prends toujours en compte l'histoire médicale de chaque personne et je travaille en lien avec les médecins. Si vous le souhaitez, je vous invite à me contacter directement au cabinet pour en parler. Bonne journée. »

4. Attendre le lendemain avant de répondre et faire relire la réponse ; si la patiente est identifiée, lui proposer un échange téléphonique ou un nouveau rendez-vous ; faire le point sur sa pratique (explications données, lien avec le médecin traitant).

5. Si l'avis contient des propos injurieux ou diffamatoires, des informations fausses présentées comme des faits, ou s'il ne correspond à aucune expérience réelle, elle peut demander le retrait à la plateforme qui héberge l'avis, puis, si besoin, saisir la justice. Un avis négatif mais sincère relève de la liberté d'expression.

Partie 8 – Synthèse : droits, responsabilité, dignité et cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Analyser un dilemme avec la grille en cinq étapes et argumenter une décision.
- Relier une situation aux textes sur les droits des usagers.
- Distinguer responsabilité civile, pénale et disciplinaire, et exploiter une enquête de toxi-infection.
- Organiser une aide alimentaire qui respecte la dignité des personnes.
- Rédiger la partie « éthique » d'une fiche projet.
- Traiter un cas complet au format de l'épreuve E5.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Grille en cinq étapes : faits, règles, valeurs en tension, options (au moins trois), décision justifiée, partagée, tracée et réévaluée.
- Loi du 2 janvier 2002 : livret d'accueil, contrat de séjour, conseil de la vie sociale, projet personnalisé ; charte des droits et libertés de la personne accueillie (2003).
- Loi du 4 mars 2002 : information, consentement, accès au dossier, secret.
- Article L. 266-1 du Code de l'action sociale et des familles (loi EGalim, 2018) : lutte contre la précarité alimentaire dans le respect de la dignité et de la capacité à agir.
- Responsabilité civile : faute, dommage, lien de causalité, réparation ; pénale : infraction, sanction ; disciplinaire : employeur.
- TIAC : au moins deux cas groupés de symptômes similaires rapportés à une même origine alimentaire ; maladie à déclaration obligatoire auprès de l'ARS.

Exercice 6.43 – Le judoka qui doit « faire le poids » (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans un club omnisports (fictif). L'entraîneur de judo vous demande un « plan pour faire perdre 3 kg en 10 jours » à Yanis, 15 ans, 52 kg, afin qu'il combatte dans la catégorie des moins de 50 kg au championnat régional. Les parents ne sont pas au courant. Yanis est d'accord : « Tout le monde fait ça, je mettrai un K-way pour transpirer. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la perte de poids demandée en pourcentage du poids de Yanis. (1 pt)

2. Analysez la situation avec la grille en cinq étapes. (6 pts)

3. Rédigez votre réponse orale à l'entraîneur (4 à 5 lignes). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.44 – Des droits très concrets au foyer (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans un foyer d'accueil médicalisé (fictif) pour adultes en situation de handicap. La direction veut revoir l'organisation des repas.

Document 1 – Six situations

a) M. D. demande à prendre son petit déjeuner dans sa chambre, à l'heure qu'il veut.

b) La direction veut supprimer le goûter pour faire des économies.

c) Mme P. demande à voir ce que la diététicienne a noté dans son dossier.

d) Une famille demande que son fils, adulte et sous mesure de protection, ne mange plus jamais de dessert.

e) Les résidents veulent un repas à thème choisi par eux chaque mois.

f) M. K. refuse l'eau gélifiée prescrite pour ses troubles de la déglutition.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque situation, citez le droit ou l'outil en jeu (texte, instance ou document). (6 pts)
2. Expliquez le rôle du conseil de la vie sociale pour les situations b) et e). (2 pts)
3. Indiquez la conduite à tenir pour la situation f). (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.45 – Responsabilité et toxi-infection après un buffet (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calculs et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre social (fictif) a organisé un buffet préparé par les participants à la fin d'un cycle d'ateliers. Le lendemain, plusieurs personnes ont des diarrhées et des vomissements. Pendant le buffet, une enfant s'est aussi brûlé la main avec une plaque restée chaude, faute de surveillance.

Document 1 – Enquête alimentaire auprès des 34 convives (données fictives)

11 convives sont malades. Parmi les 18 personnes qui ont mangé le taboulé, 10 sont malades ; parmi les 16 qui n'en ont pas mangé, 1 est malade. Parmi les 20 personnes qui ont mangé le poulet froid, 6 sont malades ; parmi les 14 qui n'en ont pas mangé, 5 sont malades. Le taboulé, préparé la veille, est resté quatre heures dans une voiture avant le buffet.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux d'attaque global, puis le taux d'attaque chez les exposés et les non-exposés et le risque relatif pour chaque plat. (4 pts)
2. Concluez sur l'aliment suspect en restant prudent. (2 pts)
3. Indiquez si la situation est une TIAC et ce que la structure doit faire. (2 pts)
4. Pour la brûlure de l'enfant, distinguez les responsabilités civile, pénale et disciplinaire qui pourraient être engagées. (3 pts)
5. Citez une mesure de prévention pour chacun des deux incidents. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.46 – La dignité à l'épicerie solidaire (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association (fictive) transforme sa distribution de colis en épicerie solidaire. Les clients paient 20 % du prix des produits. Le bureau vous soumet son projet de règlement intérieur.

Document 1 – Extrait du projet de règlement (fictif)

1. Les bénéficiaires présentent à chaque passage leur dossier social à l'accueil, devant la file d'attente.
2. Les achats de sodas et de confiseries sont interdits aux familles bénéficiaires.
3. La participation à deux ateliers cuisine par mois est obligatoire pour conserver l'accès.
4. Les produits frais sont réservés aux familles « qui font des efforts ».
5. Une carte de fidélité nominative permet de suivre les achats de chaque famille.

À vous de jouer – Questions

1. Un panier a une valeur de 42 €. Calculez ce que paie la famille à 20 %, puis ce qu'elle paierait à 10 % et à 30 %. (2 pts)
2. Expliquez en quoi l'épicerie solidaire respecte mieux la dignité que le colis imposé. (2 pts)
3. Analysez chaque article du document 1 au regard de la dignité, de la justice et de l'autonomie, et proposez une nouvelle rédaction. (6 pts)
4. Proposez une façon de faire participer les clients à la vie de l'épicerie. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.47 – Rédiger la partie « éthique » d'une fiche projet (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – rédaction · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous présentez à l'oral, devant un jury, un projet « Petits déjeuners au lycée professionnel » (fictif) : petits déjeuners gratuits deux matins par semaine, questionnaire de satisfaction en ligne, photos pour le site du lycée, partenariat avec une boulangerie du quartier. Un membre du jury vous dit : « Votre fiche ne parle pas d'éthique. »

À vous de jouer – Questions

1. Rédigez une rubrique « Éthique et cadre juridique » de la fiche projet en six points : principes, confidentialité, données, image, partenariat, participation. (8 pts)
2. Formulez la phrase d'ouverture de votre réponse orale au jury. (1 pt)
3. Le jury demande : « Pourquoi ne pas réserver les petits déjeuners aux élèves boursiers ? » Répondez en vous appuyant sur l'universalisme proportionné et sur le risque de stigmatisation. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.48 – Cas complet : les repas partagés du foyer de jeunes travailleurs (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 1 h 45*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes diététicien en stage dans un foyer de jeunes travailleurs, « Les Quatre Vents » (données fictives). Il loge 86 jeunes de 18 à 30 ans, apprentis, salariés en contrat court ou étudiants salariés, dans des studios avec une kitchenette. L'équipe socio-éducative constate que beaucoup de jeunes mangent seuls et sautent des repas. Elle vous confie un projet de dix « repas partagés » mensuels, cuisinés ensemble dans la cuisine collective, pour 25 participants à chaque fois.

Document 1 – Résultats de l'enquête de diagnostic (52 répondants sur 86, données fictives, 2027)

Réponse	Nombre de jeunes
Mange seul le soir au moins 5 jours sur 7	38
Saute au moins un repas par jour	21
Dispose de moins de 50 € par semaine pour se nourrir	29
Souhaite participer à des repas cuisinés ensemble	33
Accepte d'être pris en photo pendant les repas	17

Document 2 – Premier projet de questionnaire, rédigé par un animateur

« Nom, prénom, numéro de studio. Poids et taille. Religion. Revenus du mois dernier. Avez-vous déjà eu des problèmes avec la nourriture (anorexie, boulimie) ? Questionnaire obligatoire, à rendre à l'accueil. »

Document 3 – Une proposition reçue par courriel

Une enseigne de plats cuisinés surgelés propose de fournir gratuitement les plats des dix repas. En contrepartie : logo sur les affiches, distribution de bons de réduction et collecte des adresses électroniques des jeunes pour sa lettre d'information.

Document 4 – Recette du premier repas : gratin de chou-fleur et pommes de terre à la dinde, clémentines. Quantités nettes par portion (Ciqual 2025 pour 100 g ; prix relevés, fictifs)

Ingrédient (code Ciqual)	Par portion	kcal	Protéines (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Vitamine C (mg)	Prix
Chou-fleur, cru (20016)	150 g	24,9	1,81	0,7	2,2	0,015	23	48,2	2,80 € le kg, 40 % de pertes
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	150 g	80	2,02	0,09	2,2	< 0,0011	14,3	19,7	1,60 € le kg, 15 % de pertes
Dinde, escalope crue (36304)	90 g	108	23,7	1,48	0	0,28	11	0	11,90 € le kg
Lait demi-écrémé, pasteurisé (19042)	120 g	46,4	3,19	1,54	0	0,078	119	1,6	1,05 € le litre (1 L compté 1 kg)
Farine de blé T55 (9436)	10 g	350	9,03	1	3,2	< 0,13	23	< 0,5	1,10 € le kg

Ingrédient (code Ciqual)	Par portion	kcal	Protéines (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Vitamine C (mg)	Prix
Beurre doux, 80 % MG (16400)	8 g	753	0,64	83	0	0,035	19,8	0	9,80 € le kg
Emmental râpé (12118)	15 g	368	27,6	28,2	0,042	0,68	977	< 0,5	10,50 € le kg
Clémentine ou mandarine, chair crue (13024)	120 g	45,5	0,81	< 0,5	1,7	< 0,013	23	49,2	3,20 € le kg, 25 % de pertes
Sel, poivre, muscade									forfait 0,40 € pour 10

Les valeurs « < » sont comptées 0. Le sel ajouté en cuisine n'est pas compté.

Document 5 – Ce qui s'est passé au premier repas

- Un participant a filmé la soirée et veut publier la vidéo sur le compte du foyer.
- À la fin du repas, Théo, 19 ans, confie au stagiaire : « Depuis que j'ai perdu mon contrat, je ne mange qu'une fois par jour. Je ne veux pas que l'équipe le sache, j'ai peur de perdre mon logement. »

Document 6 – Budget du projet

Le foyer dispose de 1 000 € pour les dix repas. Il faut prévoir 180 € de petit matériel et 60 € d'impressions. Chaque participant donne 1 € par repas.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de réponse à l'enquête et le pourcentage de chaque réponse du document 1 parmi les répondants. Commentez la limite liée à la non-réponse. (4 pts)
2. Analysez les enjeux éthiques du projet avec les quatre principes de Beauchamp et Childress et un principe propre à la santé publique. (6 pts)
3. Relevez les problèmes du questionnaire du document 2 au regard du RGPD et de l'éthique, puis proposez une version corrigée de ses questions. (5 pts)
4. Calculez pour une portion l'énergie, les protéines, les lipides, les fibres, le sel, le calcium et la vitamine C, puis la part de l'énergie apportée par les protéines et par les lipides. Calculez le coût du repas pour 10 portions et par portion. Commentez. (7 pts)
5. Pour 10 repas de 25 portions au coût calculé, vérifiez que le budget du document 6 suffit, en tenant compte de la participation des jeunes. (3 pts)
6. Analysez la proposition du document 3 et rédigez la réponse au partenaire. (5 pts)
7. Indiquez les conditions pour publier la vidéo du document 5. (4 pts)
8. Indiquez la conduite à tenir après la confidence de Théo, en respectant le secret et sa sécurité. (6 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 6.43

1. 3 / 52 = **5,8 %** du poids en 10 jours.

2. Faits : un mineur de 15 ans, une demande de l'entraîneur, des parents non informés, une méthode envisagée (transpiration sous un K-way) qui déshydrate. Règles : le stagiaire n'agit que sous la responsabilité de son tuteur ; un mineur ne peut pas consentir seul à une prise en charge qui comporte un risque ; les fédérations sportives encadrent les pesées, et la perte de poids rapide est déconseillée chez l'adolescent. Valeurs en tension : autonomie (souhait de Yanis) et respect du projet sportif contre non-malfaisance (déshydratation, malaise, blessure, troubles du comportement alimentaire, croissance). Options : a) faire le plan demandé (rejetée : dangereux) ; b) refuser sans explication (rejetée : l'entraîneur et Yanis risquent de le faire seuls) ; c) refuser la perte rapide, informer le tuteur, proposer que Yanis combatte dans sa catégorie actuelle et organiser un entretien avec Yanis, ses parents et le médecin du sport. Décision : option c, justifiée par la non-malfaisance, partagée avec le tuteur, tracée dans le journal de stage, réévaluée après l'entretien.

3. Exemple : « Je comprends l'enjeu de la compétition. Mais perdre près de 6 % de son poids en dix jours, surtout en transpirant, est dangereux pour un adolescent de 15 ans : déshydratation, perte de force, malaise. Je ne peux pas faire ce plan. Je vous propose qu'il combatte dans sa catégorie et que l'on organise avec ses parents et le médecin du club un suivi de son alimentation pour la saison. »

Corrigé – Exercice 6.44

1. a) Respect des choix et de l'intimité (charte des droits et libertés de la personne accueillie, 2003) ; projet personnalisé. b) Organisation de la vie quotidienne : avis du conseil de la vie sociale (loi du 2 janvier 2002). c) Droit d'accès au dossier (loi du 4 mars 2002). d) Respect de l'autonomie de l'adulte : la mesure de protection ne donne pas à la famille le droit d'imposer un régime ; on recherche l'avis de la personne et on en parle en équipe et avec le médecin. e) Participation des personnes : conseil de la vie sociale, projet d'établissement. f) Droit au refus de soins après information (loi du 4 mars 2002).

2. Le conseil de la vie sociale, qui réunit des représentants des résidents, des familles et des professionnels, donne son avis sur l'organisation des repas : il doit être consulté avant la suppression du goûter (b), et il peut porter et organiser la demande de repas à thème (e).

3. Comprendre le refus (goût, texture, sentiment d'être infantilisé), expliquer le risque de fausse route avec des mots simples, chercher des alternatives avec l'orthophoniste et le médecin (eau gazeuse fraîche, épaississant dans une boisson qu'il aime), tracer le refus et l'information donnée dans le dossier, et respecter sa décision s'il maintient son refus.

Corrigé – Exercice 6.45

1. Taux d'attaque global : 11 / 34 = **32,4 %**. Taboulé : exposés 10 / 18 = **55,6 %** ; non-exposés 1 / 16 = **6,3 %** ; RR = 55,6 / 6,3 = **8,9**. Poulet : exposés 6 / 20 = **30,0 %** ; non-exposés 5 / 14 = **35,7 %** ; RR = **0,84**.

2. Le taboulé est l'aliment suspect : le risque est près de neuf fois plus élevé chez ceux qui en ont mangé, et il a subi une rupture de la chaîne du froid. Le poulet n'est pas associé à la maladie (RR proche de 1). Seule l'analyse microbiologique des restes et des selles permettrait de confirmer.

3. Oui : au moins deux cas groupés aux symptômes similaires rapportés à une même origine alimentaire. La structure déclare la TIAC à l'agence régionale de santé, conserve les restes au froid, oriente les malades vers un médecin et participe à l'enquête.

4. Civile : la famille peut demander la réparation du dommage (faute de surveillance, dommage, lien de causalité), prise en charge par l'assurance de la structure. Pénale : des blessures involontaires peuvent être poursuivies si une négligence est établie. Disciplinaire : l'employeur peut sanctionner un salarié qui n'a pas respecté les consignes de sécurité.

5. TIAC : transport en glacière avec un contrôle de la température, préparation le jour même. Brûlure : zone

de cuisson interdite aux enfants et surveillée par un adulte désigné.

Corrigé – Exercice 6.46

1. 42 × 0,20 = **8,40 €** ; à 10 % : **4,20 €** ; à 30 % : **12,60 €**.
2. Les clients choisissent leurs produits selon leurs goûts, leurs habitudes et leur culture, et ils paient une part : ils sont acteurs et non plus assistés. C'est le sens de l'article L. 266-1 du Code de l'action sociale et des familles (dignité et capacité à agir).
3. Article 1 : atteinte à la confidentialité et humiliation publique ; nouvelle rédaction : « L'inscription se fait une fois, en entretien individuel ; une carte d'accès simple est ensuite présentée à la caisse. » Article 2 : atteinte à l'autonomie et discrimination (les autres clients ne sont pas contrôlés) ; nouvelle rédaction : « L'épicerie propose surtout des produits de base, des fruits et des légumes ; des ateliers et des dégustations sont proposés à tous. » Article 3 : la participation contrainte n'est pas libre et conditionne un droit ; nouvelle rédaction : « Des ateliers cuisine sont proposés chaque mois, la participation est libre. » Article 4 : critère moral injuste et arbitraire ; nouvelle rédaction : « Les produits frais sont accessibles à tous les clients, dans la limite des stocks, avec un plafond par passage identique pour tous. » Article 5 : surveillance des achats sans finalité nécessaire (minimisation) ; nouvelle rédaction : « Seul le montant total des achats du mois est enregistré, pour le respect du plafond. »
4. Exemple : créer un comité de clients bénévoles qui choisit une partie des produits, propose des recettes, participe à l'accueil et donne son avis sur le règlement.

Corrigé – Exercice 6.47

1. Principes : le projet respecte l'autonomie (participation libre), la bienfaisance (petit déjeuner équilibré et plaisir), la non-malfaisance (aucun message culpabilisant, aucune pesée) et la justice (accès gratuit pour tous). Confidentialité : aucune information sur la situation des familles n'est demandée ni diffusée ; ce qui est confié aux animateurs reste dans l'équipe éducative si nécessaire. Données : questionnaire anonyme, facultatif, avec note d'information, sans donnée de santé, outil de sondage hébergé dans l'Union européenne, résultats globaux seulement. Image : autorisations écrites des élèves majeurs et des parents des mineurs, photos de mains et de tables plutôt que de visages, possibilité de retrait. Partenariat : convention écrite avec la boulangerie, au prix coûtant ou en don, mention sobre du partenaire, aucune publicité auprès des élèves. Participation : les élèves délégués et le conseil de la vie lycéenne choisissent les produits et l'organisation avec l'infirmière.
2. Exemple : « Vous avez raison, je n'ai pas assez rendu visible la dimension éthique, alors qu'elle a guidé chaque choix du projet. »
3. Réserver les petits déjeuners aux boursiers désignerait ces élèves devant les autres, et beaucoup ne viendraient pas. D'autres élèves, non boursiers, arrivent aussi le ventre vide. L'universalisme proportionné consiste à offrir une action à tous, avec une intensité plus forte là où les besoins sont les plus grands : petits déjeuners ouverts à tous, et attention particulière aux classes où l'infirmière repère le plus de besoins.

Corrigé – Exercice 6.48

1. Taux de réponse : 52 / 86 = **60,5 %**. Mange seul le soir : 38 / 52 = **73,1 %** ; saute au moins un repas : 21 / 52 = **40,4 %** ; moins de 50 € par semaine : 29 / 52 = **55,8 %** ; souhaite participer : 33 / 52 = **63,5 %** ; accepte la photo : 17 / 52 = **32,7 %**. Limite : 34 jeunes n'ont pas répondu, peut-être les plus isolés ou ceux qui travaillent en horaires décalés ; les pourcentages ne s'appliquent qu'aux répondants.
2. Autonomie : participation libre, choix des menus avec les jeunes, aucune obligation liée au logement. Bienfaisance : rompre l'isolement, apprendre à cuisiner à petit prix, améliorer l'alimentation de jeunes qui sautent des repas (40,4 %). Non-malfaisance : pas de discours culpabilisant, pas de pesée, pas d'exposition des difficultés financières (55,8 % ont moins de 50 € par semaine). Justice : un prix

symbolique (1 €) qui ne doit exclure personne, horaires adaptés aux jeunes qui travaillent tard. Principe de santé publique : la proportionnalité et la participation (associer les jeunes au choix des recettes), ou l'universalisme proportionné (ouvert à tous, attention aux plus isolés).

3. Problèmes : nom et numéro de studio rendent le questionnaire identifiant ; poids, taille et antécédents de troubles du comportement alimentaire sont des données de santé, non nécessaires au projet ; la religion est une donnée sensible, demandée sans justification ; les revenus sont intrusifs ; le caractère obligatoire est contraire à la liberté de participer ; aucune note d'information. Version corrigée : questionnaire anonyme et facultatif, avec note d'information ; questions : « Combien de soirs par semaine mangez-vous seul ? », « Combien de repas prenez-vous par jour en général ? », « Quel budget consacrez-vous à l'alimentation par semaine ? (moins de 30 €, 30 à 50 €, plus de 50 €) », « Aimeriez-vous participer à des repas cuisinés ensemble ? », « Quels plats aimeriez-vous cuisiner ? », « Avez-vous des habitudes ou des interdits alimentaires dont il faut tenir compte pour les menus (facultatif) ? ».

4. Énergie : 37,35 + 120,00 + 97,20 + 55,68 + 35,00 + 60,24 + 55,20 + 54,60 = **515,27 kcal**. Protéines : 2,71 + 3,03 + 21,33 + 3,83 + 0,90 + 0,05 + 4,14 + 0,97 = **36,97 g**. Lipides : 1,05 + 0,14 + 1,33 + 1,85 + 0,10 + 6,64 + 4,23 + 0 = **15,34 g**. Fibres : 3,30 + 3,30 + 0 + 0 + 0,32 + 0 + 0,01 + 2,04 = **8,97 g**. Sel : 0,02 + 0 + 0,25 + 0,09 + 0 + 0,00 + 0,10 + 0 = **0,47 g** (hors sel ajouté). Calcium : 34,50 + 21,45 + 9,90 + 142,80 + 2,30 + 1,58 + 146,55 + 27,60 = **386,68 mg**. Vitamine C : 72,30 + 29,55 + 0 + 1,92 + 0 + 0 + 0 + 59,04 = **162,81 mg**. Part de l'énergie : protéines 36,97 × 4 / 515,27 = **28,7 %** ; lipides 15,34 × 9 / 515,27 = **26,8 %**. Coût pour 10 portions : chou-fleur 1 500 / 0,60 = 2 500 g bruts, 7,00 € ; pommes de terre 1 500 / 0,85 = 1 764,7 g bruts, 2,82 € ; dinde 900 g, 10,71 € ; lait 1,2 L, 1,26 € ; farine 100 g, 0,11 € ; beurre 80 g, 0,78 € ; emmental 150 g, 1,58 € ; clémentines 1 200 / 0,75 = 1 600 g bruts, 5,12 € ; forfait 0,40 €. Total : **29,78 €**, soit **2,98 € par portion**. Commentaire : le repas est complet, riche en protéines (la dinde apporte plus de la moitié), en calcium (386,68 mg, environ 41 % des 950 mg conseillés par l'Anses à partir de 25 ans) et en vitamine C (chou-fleur cru dans le calcul : la cuisson en détruit une partie, la clémentine assure l'apport). Il est peu salé avant assaisonnement. Pour 515 kcal, il est un peu léger pour un jeune actif : on peut ajouter du pain. Le coût est surtout lié à la dinde (36,0 % du total) : on peut la remplacer en partie par des œufs ou des lentilles lors d'un autre repas, et c'est une recette facile à refaire dans une kitchenette.

5. 10 × 25 = 250 portions × 2,978 € = **744,50 €** ; avec le matériel et les impressions : 744,50 + 180 + 60 = **984,50 €**. Ressources : 1 000 € + 250 × 1 € = **1 250 €**. Solde : **265,50 €**. Le budget suffit, avec une marge qui peut financer un repas de plus ou des boîtes pour emporter les restes.

6. Les plats surgelés ne permettent pas de cuisiner ensemble, ce qui est le cœur du projet. Le logo et les bons de réduction feraient de l'action une opération publicitaire auprès d'un public jeune et à petit budget. La collecte des adresses électroniques est une utilisation commerciale de données personnelles, interdite sans consentement libre et spécifique, et contraire à la finalité du projet. C'est une proposition à refuser. Exemple de réponse : « Madame, Monsieur, nous vous remercions de votre proposition. Notre projet repose sur la cuisine faite ensemble par les jeunes, et il exclut toute publicité ou collecte de données personnelles. Nous ne pouvons donc pas y donner suite. Veuillez agréer nos salutations distinguées. »

7. Seuls 32,7 % des répondants acceptent d'être photographiés. Il faut l'autorisation écrite et spécifique de chaque personne reconnaissable (support, durée, possibilité de retrait) ; flouter ou couper les personnes qui ne l'ont pas donnée ; vérifier qu'aucune information confidentielle n'apparaît ; faire valider la vidéo par l'équipe avant publication sur le compte du foyer, jamais sur un compte personnel.

8. Remercier Théo de sa confiance et le rassurer : la confidence ne sera pas utilisée contre lui. Le stagiaire est tenu à la discrétion professionnelle. Il ne peut pas promettre un secret absolu, mais il explique qu'il souhaite en parler à son tuteur, et pourquoi. Il cherche l'accord de Théo pour partager le strict nécessaire avec le travailleur social référent, dans son intérêt (aide alimentaire d'urgence, droits au chômage, aides au logement) ; il précise que perdre son emploi ne fait pas perdre le logement. Il lui donne des solutions immédiates : épicerie solidaire, restaurants solidaires, aide alimentaire du CCAS. Si Théo refuse, le stagiaire en parle à son tuteur sans dévoiler plus que nécessaire, et l'on reste disponible. S'il exprime un danger grave pour sa santé ou sa vie, la protection de la personne prime : on alerte l'équipe et, si besoin, le 15 ou le 3114 (numéro national de prévention du suicide). Il note seulement les faits utiles dans le journal de stage, sans jugement.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Distinguer morale, éthique, déontologie et droit ; appliquer les quatre principes ; justifier une mesure avec les conditions de Childress ; utiliser l'échelle du Nuffield Council ; évaluer un nudge ; repérer un message stigmatisant	6.1 à 6.6			
2	Situer le cadre de la profession ; appliquer le secret professionnel, en groupe et en équipe ; réagir face à un enfant en danger ; respecter neutralité et laïcité dans les menus	6.7 à 6.12			
3	Classer une donnée (identifiante, pseudonymisée, anonyme) ; répondre aux droits des personnes ; gérer le cycle de vie et la conservation des données ; éviter les petits effectifs qui identifient ; analyser une application	6.13 à 6.18			
4	Vérifier les qualités d'un consentement ; appliquer le droit à l'image ; rédiger une autorisation ; recueillir le consentement des personnes vulnérables et des mineurs	6.19 à 6.24			
5	Gérer un lien d'intérêts ; classer des partenariats ; calculer une part de financement privé ; appliquer le Code de l'OMS de 1981 ; lire une déclaration d'intérêts	6.25 à 6.30			
6	Distinguer les types d'allégations ; vérifier une allégation nutritionnelle par le calcul ; analyser la publicité et les messages sanitaires ; conseiller sur un complément et signaler en nutrivigilance ; analyser une publication d'influenceur	6.31 à 6.36			
7	Classer un projet d'enquête ou de recherche ; rédiger une note d'information ; calculer un taux de participation et discuter les biais ; gérer son identité numérique ; utiliser l'IA de façon responsable ; répondre à un avis en ligne	6.37 à 6.42			
8	Analyser un dilemme en cinq étapes ; relier une situation aux droits des usagers ; distinguer les responsabilités ; exploiter une enquête de TIAC ; respecter la dignité dans l'aide alimentaire ; traiter un cas complet	6.43 à 6.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5

CHAPITRE

06

Éthique et déontologie en santé publique

Valeurs | Principes | Secret | Données | Image

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 6 229
Mode d'emploi du cahier d'annales 229
Ce que le jury attend sur ce chapitre 229
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 231
S1 – « Je préfère sauter le repas plutôt que d'en parler » : une enquête sur l'insécurité alimentaire étudiante et ses enjeux éthiques 231
S2 – « Cuisiner sans alcool, et sans être jugé » : un atelier culinaire en soins de réadaptation en addictologie 235
S3 – « Mon coach dit que sans poudre, je ne prendrai jamais de muscle » : compléments alimentaires, influence et éthique dans une salle de sport associative 239
Partie II – Les corrigés détaillés 244
Corrigé S1 – « Je préfère sauter le repas plutôt que d'en parler » : une enquête sur l'insécurité alimentaire étudiante et ses enjeux éthiques 244
Corrigé S2 – « Cuisiner sans alcool, et sans être jugé » : un atelier culinaire en soins de réadaptation en addictologie 251
Corrigé S3 – « Mon coach dit que sans poudre, je ne prendrai jamais de muscle » : compléments alimentaires, influence et éthique dans une salle de sport associative 257
Grille d'auto-évaluation 264

Cahier d'annales E5 – chapitre 6

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les marques, les personnes et les données des enquêtes sont fictives : elles sont construites pour l'entraînement et ne doivent pas être citées comme des données réelles. Les données nationales et les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Je préfère sauter le repas plutôt que d'en parler » : une enquête sur l'insécurité alimentaire étudiante et ses enjeux éthiques	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Cuisiner sans alcool, et sans être jugé » : un atelier culinaire en soins de réadaptation en addictologie	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Mon coach dit que sans poudre, je ne prendrai jamais de muscle » : compléments alimentaires, influence et éthique dans une salle de sport associative	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 6 porte sur l'éthique et la déontologie en santé publique : distinction entre morale, éthique, déontologie et droit ; principes de Beauchamp et Childress et principes propres à la santé publique (justice, proportionnalité, moindre contrainte, non-stigmatisation) ; cadre professionnel du diététicien ; secret professionnel et secret partagé ; protection des données (RGPD) ; consentement et droit à l'image ; conflits d'intérêts et partenariats ; allégations, publicité et compléments alimentaires ; enquêtes et recherche ; identité numérique ; laïcité et neutralité. Le jury vérifie que le candidat sait **repérer** l'enjeu éthique d'une situation concrète, **nommer** la règle ou le principe en jeu avec sa source, **proposer** une réponse respectueuse des personnes et réaliste pour la structure, et **la formuler** de façon claire et courtoise. Il valorise la nuance (un partenariat n'est pas interdit par principe, il doit être encadré) et pénalise les réponses moralisatrices ou approximatives sur le droit.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; surligner les personnes concernées, les données personnelles en jeu, les partenaires et leurs intérêts, et le verbe de chaque consigne. Pendant : pour chaque situation, suivre la grille en cinq étapes (faits, règles, valeurs en tension, options, décision) ; citer la règle avec sa référence (RGPD, Code pénal, Code civil, Code de la santé publique) ; écrire la réponse que vous donneriez réellement à la personne, en une ou deux phrases. Pour chaque donnée chiffrée, écrire le calcul, le résultat et une phrase d'interprétation. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une

semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Je préfère sauter le repas plutôt que d'en parler » : une enquête sur l'insécurité alimentaire étudiante et ses enjeux éthiques

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II).

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année au service de santé étudiante (SSE) de l'université de Haute-Lirance (structure et territoire fictifs). L'infirmière responsable et le vice-président chargé de la vie étudiante vous confient une demande : « Les associations étudiantes nous disent que beaucoup d'étudiants sautent des repas. Nous avons lancé une enquête en ligne, mais nous voulons aller plus loin : un nouveau questionnaire, des actions sur le campus et, peut-être, un partenariat avec une enseigne de restauration rapide qui nous propose des repas gratuits. » Vous devez analyser la situation, concevoir un projet respectueux des personnes, en réaliser une partie pendant votre stage et en rendre compte dans votre dossier E5. L'éthique et la protection des données sont au cœur de la demande.

Document 1 – Le campus, le public et les moyens

- 9 600 étudiants inscrits sur le campus principal, dont 56 % de femmes et 38 % d'étudiants boursiers sur critères sociaux.
- Un restaurant universitaire (repas à 1 € pour les boursiers et les étudiants en situation de précarité), ouvert de 11 h 30 à 13 h 45 du lundi au vendredi ; une cafétéria ; aucun lieu de restauration le soir ni le week-end sur le campus.
- Une association étudiante gère une épicerie à petits prix ouverte deux après-midi par semaine (accès sur dossier, après entretien avec une assistante sociale).
- Ressources : une infirmière, un médecin à mi-temps, une assistante sociale, une psychologue, des étudiants relais santé (12 étudiants formés et rémunérés) ; une salle de cours équipée d'une cuisine pédagogique (6 postes) dans le bâtiment des sciences.
- Budget de l'action : 2 500 € pour l'année universitaire (hors salaires), financé par la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC).

Document 2 – Résultats de l'enquête en ligne de mars (données fictives)

Questionnaire diffusé par la messagerie de l'université ; 1 152 répondants volontaires. L'insécurité alimentaire a été mesurée par une version française du module court en six questions du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA, 2012) : un score de 0 ou 1 correspond à une sécurité alimentaire élevée ou marginale, de 2 à 4 à une faible sécurité alimentaire, de 5 ou 6 à une très faible sécurité alimentaire. On parle d'insécurité alimentaire pour un score de 2 ou plus.

Groupe	Répondants	Score de 2 ou plus (insécurité alimentaire)
Étudiants boursiers	418	196
Étudiants non boursiers	734	198

Groupe	Répondants	Score de 2 ou plus (insécurité alimentaire)
Femmes	783	290
Hommes	369	104
Ensemble	1 152	394, dont 141 avec un score de 5 ou 6

Autres résultats : 437 répondants déclarent avoir sauté au moins un repas par semaine « par manque d'argent » au cours du dernier mois ; 61 % des répondants en insécurité alimentaire ne connaissent pas l'épicerie étudiante ; parmi ceux qui la connaissent, 72 % n'ont jamais fait de demande. Raisons citées : « peur d'être jugé » (54 %), « dossier trop compliqué » (39 %), « horaires » (31 %) ; plusieurs réponses possibles.

Document 3 – Le projet de nouveau questionnaire proposé par le vice-président (extrait)

« Pour mieux cibler l'aide, merci de remplir ce questionnaire (environ 25 minutes). En cochant cette case, vous acceptez l'utilisation de vos réponses [X] (case déjà cochée).

1. Nom, prénom, numéro d'étudiant, adresse électronique (obligatoires).
2. Date de naissance, nationalité, religion.
3. Poids et taille actuels, poids souhaité.
4. Avez-vous un trouble du comportement alimentaire ? Avez-vous déjà eu des idées suicidaires ?
5. Montant de vos revenus et de ceux de vos parents ; nombre de repas sautés par semaine.
6. Souhaitez-vous recevoir les offres de nos partenaires ?

Vos réponses seront hébergées sur un outil gratuit de formulaires en ligne et conservées sans limite de durée. Elles pourront être transmises à nos partenaires et à l'équipe enseignante. »

Document 4 – La proposition de l'enseigne « Croc'Express » (enseigne fictive)

L'enseigne, qui a ouvert un restaurant à l'entrée du campus, propose : 500 menus gratuits (burger, frites, boisson sucrée de 40 cL) distribués aux étudiants « en difficulté » repérés par le service de santé ; son logo sur les affiches de la campagne « Bien manger à la fac » ; un stand de dégustation dans le hall ; la création, au moment du retrait du menu, d'une carte de fidélité avec l'adresse électronique de l'étudiant ; une vidéo de la distribution sur ses réseaux sociaux.

Document 5 – Paroles recueillies pendant le stage

« Je préfère sauter le repas plutôt que d'en parler. Si quelqu'un de ma promo me voit à l'épicerie… » (Léa, 20 ans, licence de droit)

« Le RU, c'est super, mais à 13 h 45 c'est fermé et j'ai cours de 12 h à 14 h. » (Karim, 22 ans, master)

« Mes parents pensent que je m'en sors. Je ne veux pas qu'ils sachent. » (Sofia, 19 ans)

« Le soir, je mange des pâtes ou des céréales. Cuisiner, je n'ai ni le temps ni le matériel : j'ai une plaque dans ma chambre. » (Thomas, 21 ans)

« Les étudiants relais, ce sont des étudiants comme nous, c'est plus simple de leur parler. » (Inaya, 23 ans)

Document 6 – Trois situations rencontrées pendant le stage

Le vice-président vous demande la liste des répondants ayant un score de 5 ou 6 « pour les appeler un par un et leur proposer de l'aide ». Une étudiante très suivie sur les réseaux sociaux propose de filmer, avec son téléphone, les étudiants qui viennent chercher un panier lors de la prochaine distribution, « pour sensibiliser ». Un enseignant-chercheur en sociologie souhaite utiliser le fichier de l'enquête de mars pour un article

scientifique.

Document 7 – Cadre et repères (données réelles)

- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) : principes de licéité, de limitation des finalités, de minimisation et de limitation de la conservation (article 5) ; le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque, et une case pré-cochée ne constitue pas un consentement valable (considérant 32 ; Cour de justice de l'Union européenne, arrêt Planet49, 2019) ; les données de santé et les données révélant les convictions religieuses sont des catégories particulières (article 9) ; une analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) est requise lorsque le traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits des personnes (article 35) ; selon les lignes directrices européennes reprises par la CNIL, elle est en principe nécessaire dès que deux critères sont réunis parmi neuf (données sensibles, personnes vulnérables, grande échelle, croisement de données…).
- Les transferts de données personnelles hors de l'Union européenne sont encadrés par le chapitre V du RGPD.
- Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 (dite loi Jardé) relative aux recherches impliquant la personne humaine.
- Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.
- Article 9 du Code civil (respect de la vie privée et droit à l'image) ; article 226-13 du Code pénal (secret professionnel).
- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : limiter les boissons sucrées et les aliments gras, sucrés, salés et ultra-transformés.

Travail à faire

Partie A – Le projet d'intervention (dossier écrit de 10 pages au plus) – C3.1 (9 points)

1. Calculez le taux de participation, la prévalence de l'insécurité alimentaire (ensemble, très faible sécurité, boursiers, non-boursiers, femmes, hommes) et la part des répondants qui sautent au moins un repas par semaine. Comparez la composition de l'échantillon à celle du campus et calculez une prévalence redressée selon le sexe. Posez le diagnostic en distinguant les types de besoins. (2 pts)

2. Analysez le projet de questionnaire du document 3 au regard du RGPD : relevez au moins huit problèmes, dites si une AIPD est nécessaire, puis rédigez une version corrigée de l'introduction et la liste des questions que vous conserveriez. (2 pts)

3. Analysez la situation avec les principes éthiques du chapitre (principes de Beauchamp et Childress, principes propres à la santé publique, stigmatisation, échelle d'intervention) et analysez la proposition de l'enseigne (document 4) avec la grille des conflits d'intérêts. Formulez le problème central, ses causes et ses conséquences. (2 pts)

4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et des objectifs opérationnels, chacun avec un indicateur, une valeur cible et une échéance. (1,5 pt)

5. Présentez le plan d'action sur l'année universitaire, construit avec les étudiants relais, et un budget qui respecte les 2 500 €. Justifiez chaque action par une notion du chapitre. (1,5 pt)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée – C3.3 (3 points)

6. Calculez le risque relatif d'insécurité alimentaire des boursiers par rapport aux non-boursiers, son intervalle de confiance à 95 % avec la formule $IC = \exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d)})$, et la différence de risque. Interprétez. Pourquoi ne peut-on pas parler de « facteur de risque » au sens causal ? (1,5 pt)

7. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la prévalence globale et la taille d'échantillon nécessaire pour une précision de ± 3 points, avec correction pour une population de 9 600 étudiants. Présentez trois biais possibles de l'enquête et leur effet probable sur le résultat. (1,5 pt)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

8. Organisez une veille sur la protection des données, l'éthique de la recherche et la précarité alimentaire étudiante : sources fiables, outils, fréquence, diffusion. (2 pts)

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique – C3.5 et C3.6 (3 points)

9. Analysez les trois situations du document 6 (secret, données personnelles, finalité, droit à l'image, influence commerciale, éthique de la recherche) et rédigez votre réponse à chacun des demandeurs. (1,5 pt)

10. Proposez une campagne de communication qui ne stigmatise pas les étudiants concernés (messages, canaux, lieux) ; rédigez la trame minutée de votre exposé de 10 minutes et listez 15 questions probables du jury. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Cuisiner sans alcool, et sans être jugé » : un atelier culinaire en soins de réadaptation en addictologie

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des sujets U62 et E5.B (bon de commande, fiche technique, organisation dans le temps, hygiène), du sujet U62 « atelier cuisine en réadaptation cardiaque » (atelier avec des patients hospitalisés) et du BTS blanc CNED E5B (calcul nutritionnel).

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Le service de soins médicaux et de réadaptation (SMR) spécialisé en addictologie de la clinique « Les Hauts de Vallière » (structure fictive) accueille, pour quatre à cinq semaines, des adultes après un sevrage. Le projet de soins comprend des ateliers d'éducation thérapeutique et de « remise en lien avec le quotidien ». La diététicienne du service vous demande de concevoir et d'animer un atelier culinaire qui permette aux patients de **reprendre confiance en leur capacité à cuisiner un repas simple et économique**, de **retrouver le plaisir de manger sans alcool**, et d'échanger sur l'alimentation après la sortie. Elle insiste : « Ici, beaucoup ont honte. L'atelier doit être un lieu où personne n'est jugé. »

Document 1 – Le public et les contraintes

- 8 patients de 29 à 63 ans (5 hommes, 3 femmes) : 6 sont hospitalisés après un sevrage d'alcool, 2 après un sevrage d'alcool et de cannabis. Plusieurs vivent seuls ; trois disent « ne plus avoir cuisiné depuis des années ».
- Monsieur G., 58 ans, a une hypertension artérielle : le médecin demande de limiter le sel.
- Madame F., 41 ans, est dénutrie (perte de 8 % de son poids en un mois, IMC 17,9) : le médecin demande d'enrichir ses repas en énergie et en protéines.
- Monsieur T., 35 ans, a de fortes envies de sucré depuis le sevrage et craint de grossir.
- Monsieur B., 63 ans, a des troubles de la mémoire et des tremblements des mains.
- Monsieur R., 46 ans, est allergique à l'œuf ; Madame L., 29 ans, ne mange pas de viande.
- Règles de l'établissement : aucun produit contenant de l'alcool, même cuit (vin, bière, alcool de cuisine, extrait de vanille alcoolisé, arômes alcoolisés) ; pas de boisson « sans alcool » imitant une boisson alcoolisée ; couteaux comptés au début et à la fin de l'atelier ; pause tabac possible à mi-parcours, à l'extérieur, encadrée par l'infirmière.
- Cuisine thérapeutique : 4 postes de travail pour 2 personnes, 4 plaques à induction, 1 four, 1 réfrigérateur ; une infirmière est présente pendant tout l'atelier.
- Budget denrées : au plus 3,20 € par portion ; on prévoit 10 portions (8 patients, l'infirmière et vous).
- Durée de l'atelier avec les patients : 2 h 15, de 9 h 30 à 11 h 45, dégustation comprise. Le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 2 – Menu imposé

Plat : boulettes de bœuf à la sauce tomate, boulgour, courgettes sautées.

Dessert : poires pochées au jus d'orange et à la cannelle.

Le candidat réalise le plat et le dessert. Il présente les adaptations pour Monsieur G., Madame F., Monsieur T., Monsieur R. et Madame L., ainsi qu'une version « à refaire chez soi » avec une seule plaque et un petit budget.

Document 3 – Grammages nets par portion, pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Bœuf haché à 5 % de matières grasses	100 g	sans perte	12,50 € le kg
Chapelure	8 g	sans perte	3,20 € le kg
Œufs (calibre moyen, 50 g net)	2 œufs pour 10 portions	sans perte	0,30 € l'œuf
Oignons	30 g	10 %	1,80 € le kg
Persil frais	3 g	20 %	20,00 € le kg
Tomates pelées en conserve, au jus	120 g	sans perte	1,60 € le kg
Huile d'olive vierge extra	8 g	sans perte	8,50 € le kg
Boulgour	60 g (cru)	sans perte	3,00 € le kg
Courgettes	150 g	10 %	2,40 € le kg
Poires	150 g	20 %	2,80 € le kg
Jus d'orange pur jus	60 g	sans perte	1,90 € le litre (1 L = 1 kg)
Ail, cumin, cannelle, gousse de vanille, thym, sel, poivre	–	–	forfait 1,00 € pour l'atelier

Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte).

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Boeuf, steak haché 5% MG cru	130	21,9	0,3	0	4,59	0	0,097	2,65	0
Chapelure	365	9,41	74,3	4,29	1,6	5,4	0,72	1,1	< 2
Oeuf cru	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31	1,75	0
Oignon, cru	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098	traces	3,9
Persil, frais	42,5	2,97	4,1	0,85	0,63	4,3	0,59	6,2	133
Tomate, pelée, appertisée, au jus, non égouttée	21,8	0,79	3,15	2,55	0,25	1,9	0,025	0,57	12,6
Huile d'olive vierge extra	899	0,25	traces	0	99,9	0	< 0,013	< 0,05	0
Boulgour de blé, cru	347	11,7	65,8	0,41	1,42	10,5	0,043	2,46	0
Courgette, chair et peau, crue	16,7	1,21	1,75	1,74	0,32	1	0,02	0,37	17,9
Poire, chair et peau, crue	56,6	0,36	12,3	9,75	0,27	2,9	0,0045	0,072	4,3
Jus d'orange, pur jus	45,4	0,61	9,61	9,61	0,11	0,28	0,012	0,068	37

Aliment (libellé Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Cannelle, poudre	243	3,99	27,5	2,17	1,24	53,1	0,025	8,32	3,8

On calcule avec les poids nets (crus ; égouttés ou non selon le libellé). Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. On compte 0,5 g de cannelle par portion ; le sel ajouté n'est pas compté. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 5 – La recette du classeur de la cuisine thérapeutique (extrait)

« Poires au vin : faire chauffer 75 cL de vin rouge avec 150 g de sucre, un bâton de cannelle, une étoile de badiane et une cuillère à café d'extrait de vanille. Pocher les poires épluchées 25 minutes à frémissement, puis réduire le sirop. Servir tiède avec une boule de glace. »

Document 6 – Trois situations qui pourraient se présenter pendant l'atelier

Le service communication de la clinique souhaite des photos de l'atelier « avec des patients souriants » pour le site internet et la page de la clinique sur un réseau social. Pendant l'épluchage, un patient vous confie à voix basse qu'il a bu pendant sa permission du week-end et vous demande de « ne rien dire à personne ». À la fin de l'atelier, une patiente vous demande votre numéro de téléphone personnel « pour vous envoyer des photos de mes plats quand je serai rentrée ».

Document 7 – Repères utiles (données réelles)

- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des féculents complets au moins une fois par jour ; réduire le sel ; limiter les boissons sucrées ; pas plus d'un verre de jus de fruits par jour.
- L'OMS (2015) recommande de limiter les sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique ; les sucres des jus de fruits font partie des sucres libres, pas ceux des fruits entiers.
- La HAS (2021) retient, chez l'adulte de moins de 70 ans, une perte de poids d'au moins 5 % en un mois ou un IMC inférieur à 18,5 parmi les critères phénotypiques du diagnostic de dénutrition.
- Le règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) impose d'informer les consommateurs sur la présence de 14 allergènes, dont les œufs et le gluten, y compris dans les denrées non préemballées.
- Article L. 1110-4 du Code de la santé publique : les professionnels d'une même équipe de soins peuvent partager les informations strictement nécessaires à la prise en charge, la personne en étant informée.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (11 points)

1. Identifiez les besoins et les ressources de ce public (savoir-faire, isolement, estime de soi, situations de santé, mémoire) et formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier. (2 pts)
2. Établissez le bon de commande pour 10 portions (quantités nettes, quantités brutes, unités de commande, coût) ; calculez le coût par portion et vérifiez le respect du budget. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique du plat et du dessert (ingrédients, matériel, étapes, points critiques). Adaptez la recette du document 5 aux règles de l'établissement et justifiez chaque modification. Présentez les adaptations pour les cinq patients cités et la version « à refaire chez soi ». (3 pts)

4. Calculez l'apport d'une portion du repas en énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, fer et vitamine C, et la répartition de l'énergie ; calculez la part des sucres libres ; commentez au regard des repères, en particulier pour Madame F. et Monsieur T. (2 pts)

5. Présentez le cadre éthique de l'atelier : règles de confidentialité énoncées aux participants, consentement, non-jugement, droit à l'image et limites de la relation professionnelle. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et participants), en organisant les binômes et la pause. (2 pts)

7. Présentez les méthodes d'animation et les outils (démonstration, fiche recette imagée, échange sur les souvenirs et le plaisir de manger, « faire dire »), ainsi qu'une grille de dégustation. (1,5 pt)

8. Présentez les règles d'hygiène (5 M, viande hachée, refroidissement, restes), la sécurité (couteaux, brûlures, tremblements), la gestion des allergènes et trois éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

9. Réalisez le plat et le dessert ; dressez une assiette et une coupe de dessert. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier (satisfaction, confiance en soi pour cuisiner, gestes retenus, intention de refaire) et dites comment vous analysez les trois situations du document 6, avec la réponse que vous donnez à chaque personne. (1 pt)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Mon coach dit que sans poudre, je ne prendrai jamais de muscle » : compléments alimentaires, influence et éthique dans une salle de sport associative

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet de synthèse – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2)

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Temps 1 : préparation conseillée 3 h, puis 30 min d'oral blanc · Temps 2 : 3 h · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique au sein du réseau de santé du quartier des Coteaux, à Saint-Aubrac (territoire fictif). Le réseau est sollicité par l'association « Force et Quartier » (structure fictive), qui gère une salle de musculation et de remise en forme à petit prix ouverte aux habitants. Le président s'inquiète : « Des jeunes adhérents achètent des poudres et des "brûleurs de graisse" sur internet, conseillés par des influenceurs ou par un de nos coachs bénévoles qui en revend. Certains ne mangent presque plus le midi pour "sécher". Une marque de compléments nous propose de financer la rénovation de la salle. » Vous devez concevoir un projet d'intervention (temps 1) et un atelier culinaire pour les adhérents (temps 2).

Temps 1 – Le projet d'intervention

Document 1 – Le public, la structure et les moyens

- 310 adhérents de 18 à 54 ans (âge médian 26 ans ; 71 % d'hommes) ; cotisation de 10 € par mois ; ouverture de 7 h à 22 h.
- Six coachs bénévoles, titulaires pour quatre d'entre eux d'un diplôme d'éducateur sportif ; aucun professionnel de santé dans l'association.
- Un espace de convivialité avec un réfrigérateur et un four à micro-ondes ; la cuisine pédagogique du centre social voisin (6 postes) peut être réservée.
- Partenaires possibles : centre social, maison de santé pluriprofessionnelle (médecins, diététicienne), mission locale, service des sports de la ville.
- Budget : 1 500 € pour l'année (hors salaires), versé par la ville.

Document 2 – Questionnaire anonyme proposé dans la salle (données fictives)

96 adhérents ont rempli un questionnaire papier anonyme, déposé dans une urne. Il comprenait, entre autres, le questionnaire de repérage SCOFF (cinq questions ; deux réponses positives ou plus orientent vers une évaluation par un professionnel, sans constituer un diagnostic).

Question	Réponses « oui » (n = 96)
Je consomme des poudres de protéines au moins trois fois par semaine	41
J'ai déjà utilisé un produit présenté comme « brûleur de graisse »	12
Je saute au moins un repas par jour pour perdre du poids ou « sécher »	23
Score SCOFF de 2 ou plus	18
Mes conseils alimentaires viennent surtout des réseaux sociaux	52
Mes conseils alimentaires viennent surtout d'un coach de la salle	29

Croisement : parmi les 12 adhérents ayant utilisé un « brûleur de graisse », 7 ont un score SCOFF de 2 ou plus ; parmi les 84 autres, 11.

Exemple d'un adhérent de 70 kg : ses repas lui apportent environ 105 g de protéines par jour, auxquels s'ajoutent trois doses de poudre par jour. Une dose de 30 g de poudre contient 24 g de protéines ; la poudre coûte 39,90 € le kilogramme.

Document 3 – L'offre de la marque « NutriForce Pro » (marque fictive)

La marque propose : 8 000 € pour la rénovation des vestiaires ; son logo dans la salle et sur les tee-shirts des coachs ; un distributeur automatique de boissons protéinées et de barres ; un code de réduction de 20 % pour les adhérents, avec une commission de 10 % pour l'association ; une « journée bilan » où un « conseiller en nutrition sportive » de la marque mesurera la masse grasse des adhérents et proposera un programme de compléments.

Document 4 – Paroles d'adhérents et de coachs

« Mon coach dit que sans poudre, je ne prendrai jamais de muscle. » (Yanis, 19 ans)

« Je vois les gars sur les réseaux, ils sont secs toute l'année. Moi, je mange une fois par jour et je prends des brûleurs. » (Mehdi, 22 ans)

« Les poudres, ça coûte cher, j'en achète à la place des courses. » (Kevin, 24 ans)

« Je vends un peu de poudre aux jeunes, ça m'arrange et ça les aide. Je n'y vois pas de mal. » (un coach bénévole)

« Je ne sais pas cuisiner, alors je prends ce qui est rapide. » (Sarah, 27 ans)

Document 5 – Deux situations rencontrées pendant le stage

Le coach qui revend des poudres vous demande de rédiger, à son nom, un « plan de sèche à 1 200 kcal » pour un adhérent de 20 ans qui prépare une compétition amateur. Le président souhaite publier sur le compte de l'association une vidéo où vous apparaissez, en tenue de stagiaire, à côté des produits de la marque, « pour montrer que la diététicienne est d'accord ».

Document 6 – Cadre et repères (données réelles)

- Directive 2002/46/CE et décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 : les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires ; ils ne sont pas des médicaments et ne peuvent pas revendiquer de propriété de prévention ou de traitement d'une maladie.
- Règlement (CE) n° 1924/2006 : seules les allégations nutritionnelles et de santé autorisées peuvent être utilisées.
- Le dispositif national de nutrivigilance, confié à l'ANSES depuis 2009, recueille les déclarations d'effets indésirables liés notamment aux compléments alimentaires.
- AFSSA (2007) : la référence nutritionnelle en protéines de l'adulte est de 0,83 g par kilogramme de poids corporel et par jour ; des apports compris entre 0,83 et 2,2 g/kg/j sont considérés comme satisfaisants chez l'adulte en bonne santé.
- Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 : toute promotion par un influenceur doit être clairement signalée (mention « publicité » ou « collaboration commerciale »).
- Le titre de diététicien est protégé (article L. 4371-1 et suivants du Code de la santé publique) ; ceux de « nutritionniste » (hors médecin) et de « coach en nutrition » ne le sont pas.
- Le questionnaire SCOFF (Morgan et coll., 1999) existe en version française validée (SCOFF-F) ; c'est un outil de repérage, pas de diagnostic.

Travail à faire – temps 1

1. Calculez les indicateurs du document 2 et le taux de participation ; posez le diagnostic en distinguant ce qui relève des personnes, de l'association et de l'environnement commercial et numérique. (2,5 pts)
2. Calculez, pour l'adhérent du document 2, l'apport en protéines en grammes par kilogramme et comparez-le aux repères ; calculez le coût d'un gramme de protéines apporté par la poudre, puis par le filet de poulet (11,50 € le kg ; 23,4 g de protéines pour 100 g), les haricots rouges en conserve (2,40 € le kg égoutté ; 8,31 g pour 100 g) et le lait demi-écrémé (0,95 € le litre ; 3,48 g pour 100 g). Concluez. (2,5 pts)
3. Analysez la situation avec les notions du chapitre : principes de Beauchamp et Childress, non-malfaisance, conflits d'intérêts, information loyale, allégations, champ de compétence et orientation. Analysez l'offre de la marque (document 3) et proposez une réponse au président. (2 pts)
4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et des objectifs opérationnels avec indicateurs ; présentez un plan d'action sur un an et un budget qui respecte les 1 500 €. (4 pts)
5. Calculez le risque relatif d'un score SCOFF de 2 ou plus selon l'utilisation d'un « brûleur de graisse » et son intervalle de confiance à 95 % (même formule que dans les autres sujets). Concluez avec prudence. Calculez l'intervalle de confiance de la proportion de scores SCOFF de 2 ou plus, et la taille d'échantillon nécessaire pour une précision de ± 5 points (population de 310). (3 pts)
6. Organisez une veille sur les compléments alimentaires, la nutrivigilance et l'influence commerciale en ligne (sources, outils, fréquence). (2 pts)
7. Analysez les deux situations du document 5 et rédigez vos réponses ; expliquez comment repérer et orienter un adhérent qui présente des signes de trouble du comportement alimentaire sans le stigmatiser. (2 pts)

Qualité de l'expression, vocabulaire et sources datées : 2 pts.

Temps 2 – L'atelier culinaire « Des protéines dans l'assiette, pas dans le shaker »

Document 7 – Le groupe et les contraintes

- 8 adhérents de 19 à 34 ans (6 hommes, 2 femmes) ; trois disent ne pas savoir cuisiner ; deux mangent halal ; Sarah est intolérante au lactose (elle tolère le yaourt et de petites quantités de lait) ; personne ne signale d'allergie.
- Un coach diplômé est présent ; cuisine pédagogique du centre social (6 postes, 2 fours, 6 plaques).
- Budget denrées : au plus 2,90 € par portion ; 10 portions (8 adhérents, le coach et vous).
- Durée avec le public : 2 h, dégustation comprise, de 18 h 30 à 20 h 30.
- Objectif fixé avec l'association : un repas du soir complet et une collation à emporter pour le lendemain, faciles à refaire en moins de 20 minutes.

Document 8 – Menu imposé et grammages (données construites pour le sujet)

Plat : wraps au poulet, haricots rouges, maïs et crudités, sauce au yaourt. Collation : pain perdu aux pommes et à la cannelle, cuit au four.

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Tortillas de blé (40 g pièce)	2 tortillas	sans perte	0,24 € la tortilla
Filet de poulet sans peau (halal pour tous)	90 g	sans perte	11,50 € le kg
Haricots rouges en conserve, égouttés	60 g	sans perte	2,40 € le kg égoutté
Maïs doux en conserve, égoutté	30 g	sans perte	3,00 € le kg égoutté
Carottes	50 g	15 %	1,40 € le kg
Laitue	20 g	25 %	4,00 € le kg
Yaourt nature (sauce)	40 g	sans perte	2,20 € le kg
Huile d'olive vierge extra	5 g	sans perte	8,50 € le kg
Pain complet rassis	50 g	sans perte	3,80 € le kg

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Lait demi-écrémé	80 g	sans perte	0,95 € le litre (1 L = 1 kg)
Œufs (50 g net)	1 œuf pour 2 portions	sans perte	0,30 € l'œuf
Pommes	100 g	15 %	2,30 € le kg
Sucre	5 g	sans perte	1,20 € le kg
Cannelle, ail, cumin, paprika, citron, sel, poivre	–	–	forfait 0,80 € pour l'atelier

Document 9 – Extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)
Tortilla souple (à garnir), à base de blé	320	8,01	53	2,12	7,48	2,89	1,41	45	0,76
Poulet, filet sans peau cru	110	23,4	0	traces	1,5	0	0,11	3,3	0,33
Haricot rouge, appertisé, égoutté	108	8,31	13	1	0,97	7	0,68	58	1,5
Maïs doux, appertisé, égoutté	105	2,66	18,3	2,37	1,68	3,1	0,59	3,51	0,35
Carotte, crue	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12	36,2	< 0,25
Laitue, crue	14,7	1,35	1,22	0,73	0,2	1,1	0,021	64,6	1,1
Yaourt ou lait fermenté, nature	50,1	3,83	4,26	4	1,68	traces	0,1	137	< 0,25
Huile d'olive vierge extra	899	0,25	traces	0	99,9	0	< 0,013	< 0,2	< 0,05
Pain complet ou intégral (à la farine T150)	234	8,66	41,2	2,41	1,7	7,3	1,17	83,2	2
Lait demi-écrémé, UHT	47,7	3,48	5	4,96	1,56	0	0,088	121	< 0,084
Oeuf cru	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31	76,8	1,75
Pomme, chair et peau, crue	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037	5,34	0,099
Sucre blanc	399	0	99,7	99,7	0	0	0,0054	3,69	0,077
Cannelle, poudre	243	3,99	27,5	2,17	1,24	53,1	0,025	1000	8,32

On compte 0,5 g de cannelle par portion ; le sel ajouté n'est pas compté. Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0.

Travail à faire – temps 2

8. Identifiez les besoins du groupe et formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier. (2 pts)

9. Établissez le bon de commande pour 10 portions et le coût par portion ; vérifiez le budget. Calculez l'apport d'une portion (wrap et pain perdu), la répartition de l'énergie et la quantité de protéines par kilogramme pour un adhérent de 70 kg ; commentez. (4 pts)

10. Rédigez la fiche technique des deux préparations et une version « en moins de 20 minutes » à refaire chez soi ; proposez les adaptations pour Sarah et pour un adhérent végétarien. (4 pts)

11. Présentez le déroulé minuté des 3 heures, les méthodes d'animation (démonstration, défi en binômes, comparaison des prix au gramme de protéines, « faire dire ») et une grille de dégustation. Indiquez comment vous abordez les compléments et la « sèche » pendant l'atelier sans juger ni culpabiliser. (4 pts)

12. Présentez les règles d'hygiène (volaille crue, œufs, refroidissement et transport de la collation, 5 M), la gestion des allergènes et trois éco-gestes. (3 pts)

13. Réalisez les deux préparations ; proposez l'évaluation de l'atelier (savoir-faire, intention de refaire, évolution de l'usage des poudres à un mois). (3 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Je préfère sauter le repas plutôt que d'en parler » : une enquête sur l'insécurité alimentaire étudiante et ses enjeux éthiques

que le jury attend

Le jury évalue la capacité à produire un diagnostic chiffré rigoureux **et** à protéger les personnes à chaque étape : collecte des données, choix des actions, communication, partenariats. Il valorise une analyse précise du questionnaire au regard du RGPD (base légale, minimisation, données sensibles, conservation, transferts, consentement), la gestion argumentée d'un partenariat commercial et des réponses courtoises mais fermes aux demandes inappropriées. Il pénalise la reprise d'un ciblage nominatif des étudiants « pauvres », les jugements (« ils ne savent pas gérer leur budget ») et les approximations juridiques.

Partie A – Le projet d'intervention

Question 1 – Indicateurs, représentativité et diagnostic (2 pts)

Calcul posé – Indicateurs de l'enquête de mars

- Taux de participation : 1 152 / 9 600 × 100 = **12,0 %**.
- Insécurité alimentaire (score de 2 ou plus), ensemble : 394 / 1 152 × 100 = **34,2 %** ; très faible sécurité (score de 5 ou 6) : 141 / 1 152 × 100 = **12,2 %**.
- Boursiers : 196 / 418 × 100 = **46,9 %** ; non-boursiers : 198 / 734 × 100 = **27,0 %**.
- Femmes : 290 / 783 × 100 = **37,0 %** ; hommes : 104 / 369 × 100 = **28,2 %**.
- Repas sautés au moins une fois par semaine par manque d'argent : 437 / 1 152 × 100 = **37,9 %**.
- Composition de l'échantillon : femmes 783 / 1 152 = **68,0 %** (56 % sur le campus) ; boursiers 418 / 1 152 = **36,3 %** (38 % sur le campus).
- Prévalence redressée selon le sexe (pondération par la part de chaque sexe sur le campus) : 0,56 × 37,04 + 0,44 × 28,18 = 20,74 + 12,40 = **33,1 %**.

Interprétation. Un répondant sur trois est en insécurité alimentaire et plus d'un sur dix en très faible sécurité alimentaire, ce qui signifie des repas réduits ou supprimés faute d'argent. Les femmes sont surreprésentées parmi les répondants (68,0 % contre 56 %) et déclarent plus souvent une insécurité : la prévalence brute surestime donc légèrement la situation ; une fois redressée selon le sexe, elle passe de 34,2 % à **33,1 %**, un écart faible. La part des boursiers est proche de celle du campus. Avec 12 % de participation et un recrutement volontaire, le résultat ne peut cependant pas être généralisé sans prudence (question 7). Le **non-recours** est central : 61 % des étudiants en insécurité ne connaissent pas l'épicerie, et 72 % de ceux qui la connaissent n'ont jamais fait de demande, principalement par **peur du jugement** (54 %).

Type de besoin (Bradshaw, 1972)	Dans la situation
Normatif	34,2 % d'insécurité alimentaire selon un instrument validé (USDA, 2012) ; 37,9 % sautent des repas ; repères de Santé publique France (2019) non atteints avec « des pâtes ou des céréales le soir »
Ressenti	Honte, peur d'être vu à l'épicerie ; volonté de cacher la situation aux parents
Exprimé	Horaires du restaurant universitaire incompatibles ; manque de matériel pour cuisiner ; dossier jugé compliqué
Comparatif	46,9 % chez les boursiers contre 27,0 % chez les non-boursiers

Diagnostic. Le problème n'est pas seulement le manque d'argent : il combine des **ressources insuffisantes**, une **offre inadaptée** (pas de restauration le soir, horaires du restaurant universitaire, épicerie ouverte deux après-midi), un **accès stigmatisant** à l'aide (dossier, entretien, peur d'être vu) et des **compétences et équipements limités** pour cuisiner (une plaque dans la chambre). Les ressources sont réelles : restaurant universitaire à 1 €, épicerie étudiante, étudiants relais à qui « c'est plus simple de parler », équipe du service de santé, cuisine pédagogique.

Question 2 – Le questionnaire au regard du RGPD (2 pts)

Problème relevé dans le document 3	Règle (RGPD sauf mention contraire)	Correction
Case de consentement déjà cochée	Consentement libre, spécifique, éclairé et univoque ; une case pré-cochée n'est pas valable (considérant 32 ; CJUE, Planet49, 2019)	Case non cochée, ou questionnaire anonyme ne nécessitant pas de consentement nominatif
Nom, prénom, numéro d'étudiant, adresse électronique obligatoires	Minimisation (article 5) ; pas nécessaires pour mesurer l'insécurité	Questionnaire **anonyme** ; contact facultatif et séparé, dans un autre formulaire, pour ceux qui veulent être recontactés
Nationalité et religion	Religion : catégorie particulière (article 9) ; nationalité sans lien avec la finalité	Supprimer
Poids, taille, poids souhaité	Données de santé (article 9) ; non nécessaires	Supprimer
TCA, idées suicidaires	Données de santé très sensibles ; questions intrusives, sans possibilité d'aide immédiate	Supprimer ; afficher plutôt les contacts de la psychologue et des lignes d'écoute
Revenus des parents	Minimisation ; question intrusive	Remplacer par une question simple et facultative (boursier ou non)
Offres des partenaires	Limitation des finalités ; mélange santé et prospection commerciale	Supprimer
Durée de 25 minutes	Respect des personnes, qualité des réponses	Questionnaire de 5 à 8 minutes
Outil gratuit de formulaires en ligne, hébergement non précisé	Sécurité (article 32) ; transferts hors de l'Union européenne encadrés (chapitre V)	Outil validé par le délégué à la protection des données de l'université, hébergé dans l'Union européenne
Conservation sans limite	Limitation de la conservation (article 5)	Durée définie, par exemple 12 mois après la fin de l'enquête, puis suppression
Transmission aux partenaires et aux enseignants	Finalité, confidentialité, secret	Aucune transmission de données individuelles ; résultats collectifs seulement
Pas de responsable, de finalité, de droits ni de contact	Information des personnes (articles 12 à 14)	Mention d'information complète

AIPD. Le projet initial réunit au moins trois critères parmi les neuf retenus par la CNIL : données sensibles (santé, religion), personnes potentiellement vulnérables (étudiants en difficulté), croisement de données (identité et revenus), et peut-être grande échelle (9 600 étudiants sollicités). Une AIPD serait donc **obligatoire** pour ce projet. La version corrigée, anonyme et minimisée, réduit fortement le risque ; on demande l'avis du **délégué à la protection des données** de l'université, qui tient le registre des traitements.

> **Exemple – Introduction corrigée du questionnaire**
>
> « Ce questionnaire est **anonyme** : il ne demande ni votre nom ni votre numéro d'étudiant. Il est proposé par

> le service de santé étudiante de l'université pour mieux comprendre les difficultés d'alimentation des étudiants et adapter les aides du campus. Il dure environ 6 minutes. Vous êtes libre de ne pas répondre, ou de ne répondre qu'à certaines questions. Les réponses sont hébergées dans l'Union européenne, consultées uniquement par l'équipe du service de santé et supprimées le [date]. Seuls des résultats d'ensemble seront publiés. Contact : [adresse du service] ; délégué à la protection des données : [adresse]. Si vous avez besoin d'aide dès maintenant : [contacts de l'assistante sociale, de l'épicerie et de la psychologue]. »

Questions conservées : les six questions du module court de l'USDA ; repas sautés par manque d'argent au cours du dernier mois ; boursier ou non (facultatif) ; logement (chez les parents, résidence universitaire, logement seul ou en colocation) ; équipement pour cuisiner ; connaissance et utilisation des aides du campus ; freins à leur utilisation ; propositions libres.

Question 3 – Analyse éthique et conflit d'intérêts (2 pts)

- **Bienfaisance** : aider les étudiants qui ont faim est légitime et urgent.
- **Non-malfaisance** : un repérage nominatif, des questions intrusives ou une distribution visible peuvent humilier et aggraver le non-recours ; un menu de restauration rapide distribué comme « aide » ne correspond pas aux repères nutritionnels.
- **Autonomie** : l'étudiant doit pouvoir choisir de demander de l'aide ou non, sans être contacté sans son accord.
- **Justice** : les boursiers sont plus touchés (46,9 % contre 27,0 %) ; l'**universalisme proportionné** justifie des actions pour tous, renforcées pour les plus touchés, sans désigner personne.
- **Principes propres à la santé publique** : non-stigmatisation, proportionnalité, moindre atteinte à la vie privée.
- **Échelle d'intervention** (Nuffield Council, 2007) : informer sur les aides (bas de l'échelle) ne suffit pas ; il faut **faciliter** les choix (horaires élargis, repas du soir, matériel, accès simplifié) plutôt que culpabiliser.

Grille des conflits d'intérêts	Proposition de l'enseigne
Intérêt secondaire	Publicité, fidélisation, collecte d'adresses électroniques, image d'entreprise « solidaire »
Risques	Message contraire aux repères (menu gras, salé, sucré, boisson sucrée de 40 cL) ; service de santé associé à une marque ; données personnelles collectées à des fins commerciales ; vidéo stigmatisante ; repérage des « étudiants en difficulté » par le service de santé, contraire au secret
Éléments acceptables	Une aide financière ou matérielle peut être utile si elle est encadrée
Réponse proposée	Refuser la distribution de menus, le logo sur la campagne de santé, la carte de fidélité et la vidéo ; proposer, si l'enseigne le souhaite, un don sans contrepartie à l'épicerie étudiante, par convention écrite, sans communication de la marque sur le campus

Problème central : une part importante des étudiants du campus est en insécurité alimentaire et recourt peu aux aides existantes, parce que l'accès à ces aides est perçu comme stigmatisant et que l'offre alimentaire du campus est inadaptée à leurs horaires et à leurs moyens. Causes : ressources insuffisantes, absence d'offre le soir, horaires, dossier et entretien pour l'épicerie, honte, équipement limité. Conséquences : repas sautés, alimentation monotone, fatigue, difficultés de concentration et risque d'échec, isolement ; risque supplémentaire si l'on collecte des données ou que l'on distribue des aides de façon stigmatisante.

Question 4 – Objectifs (1,5 pt)

Objectif général : améliorer la sécurité alimentaire des étudiants du campus en facilitant un accès digne et sans stigmatisation à une alimentation suffisante et équilibrée, d'ici la fin de l'année universitaire.

Objectif	Indicateur	Valeur de départ	Cible	Échéance
Spécifique 1 : augmenter le recours aux aides alimentaires du campus	Part des étudiants en insécurité qui connaissent l'épicerie	39 %	70 %	Enquête de mars suivante
	Part de ceux qui la connaissent et l'ont utilisée	28 %	45 %	Idem
Spécifique 2 : développer la capacité des étudiants à préparer des repas simples avec peu de moyens	Part des participants aux ateliers qui déclarent cuisiner au moins trois soirs par semaine un mois après	À mesurer au premier atelier	+ 20 points	1 mois après chaque atelier
Opérationnel : simplifier l'accès à l'épicerie	Accès sur simple déclaration, sans entretien obligatoire	Non	Oui	Décembre
Opérationnel : animer 8 ateliers « cuisiner avec une plaque »	Nombre d'ateliers et de participants	0	8 ateliers, 80 participations	Mai
Opérationnel : former les 12 étudiants relais	Part des relais formés	0 %	100 %	Novembre

Question 5 – Plan d'action et budget (1,5 pt)

Période	Action	Notion justifiant l'action
Septembre à novembre	Groupe de travail avec les étudiants relais et l'association de l'épicerie ; formation des relais à l'écoute, à l'orientation et au secret	Participation, pairs, secret
Novembre à décembre	Simplification de l'accès à l'épicerie (déclaration simple, horaires élargis en fin de journée, retrait discret) ; plaidoyer pour une offre du soir au restaurant universitaire	Échelle d'intervention : faciliter plutôt qu'informer ; moindre stigmatisation
Janvier à mai	Huit ateliers « cuisiner avec une plaque et 3 € » ouverts à tous ; prêt de kits de cuisine de chambre	Universalisme proportionné ; littératie alimentaire
Janvier à mai	Bons fruits et légumes au marché du campus, remis par les relais sur simple demande	Accès digne, choix de la personne
Toute l'année	Campagne « Bien manger à la fac, c'est pour tout le monde » ; vidéos courtes réalisées par des étudiants	Communication non stigmatisante
Mars	Nouvelle enquête anonyme (questionnaire corrigé) ; restitution des résultats aux étudiants	Évaluation, transparence

Poste	Calcul	Montant
Formation des étudiants relais	2 séances × 3 h × 45 €	270 €
Denrées des ateliers	8 ateliers × 12 personnes × 2,50 €	240 €
Kits de cuisine de chambre prêtés (casserole, poêle, planche, couteau, boîtes)	20 kits × 35 €	700 €
Bons fruits et légumes	60 bons × 10 €	600 €
Impression (affiches, cartes avec QR code vers les aides)	Devis	180 €
Matériel pour les vidéos (micro, éclairage)	Devis	150 €
Restitution et évaluation	Impression, collation	120 €
Réserve pour imprévus	–	240 €

Poste	Calcul	Montant
Total		**2 500 €**

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée

Question 6 – Risque relatif et intervalle de confiance (1,5 pt)

Calcul posé – Risque relatif d'insécurité alimentaire des boursiers

a = 196 ; a + b = 418 ; c = 198 ; c + d = 734.

- Risque chez les boursiers : 196 / 418 = **0,4689** ; chez les non-boursiers : 198 / 734 = **0,2698**.
- RR = 0,4689 / 0,2698 = **1,74**.
- ln RR = 0,5529 ; erreur type = √(1/196 − 1/418 + 1/198 − 1/734) = √(0,005102 − 0,002392 + 0,005051 − 0,001362) = √0,006398 = **0,0800**.
- IC 95 % = exp(0,5529 ± 1,96 × 0,0800) = exp(0,3961) à exp(0,7097) = **[1,49 ; 2,03]**.
- Différence de risque : 46,9 − 27,0 = **19,9 points**.

Interprétation. Parmi les répondants, les boursiers sont 1,74 fois plus souvent en insécurité alimentaire que les non-boursiers ; l'intervalle de confiance ne contient pas 1, l'association est donc **statistiquement significative**. La différence de risque montre l'ampleur absolue de l'écart : près de 20 points. On ne peut pas parler de facteur de risque au sens causal : l'enquête est **transversale** (exposition et situation mesurées au même moment) ; la bourse est un **marqueur** de faibles revenus familiaux, et ce sont ces revenus, le logement ou l'emploi qui expliquent la situation, pas la bourse elle-même ; des facteurs de confusion (âge, logement, travail salarié) n'ont pas été pris en compte ; l'échantillon est volontaire.

Question 7 – Intervalle de confiance, taille d'échantillon et biais (1,5 pt)

Calcul posé – Précision et taille d'échantillon

- p = 0,342 ; IC 95 % = p ± 1,96 × √(p × (1 − p) / n) = 0,342 ± 1,96 × √(0,342 × 0,658 / 1 152) = 0,342 ± 0,0274 = **[31,5 % ; 36,9 %]**.
- Taille d'échantillon pour ± 3 points avec p = 0,342 : n0 = 1,96² × 0,342 × 0,658 / 0,03² = **961** (960,6 arrondi à l'entier supérieur).
- Correction pour une population de 9 600 : n = n0 / (1 + (n0 − 1) / N) = 960,6 / (1 + 959,6 / 9 600) = **874** répondants.
- Si l'on ne connaît pas la prévalence, on prend p = 0,5 : n0 = 1 068, puis n = **961** après correction.

L'échantillon de 1 152 répondants est donc suffisant en **nombre**, mais pas forcément en **représentativité**.

Biais	Explication	Effet probable
Biais de volontariat (sélection)	Les étudiants concernés par le sujet répondent davantage	Surestimation de la prévalence
Biais de non-réponse	Les étudiants les plus en difficulté (qui travaillent, lisent peu leur messagerie, ont honte) répondent moins	Sous-estimation possible
Biais de déclaration (désirabilité sociale)	Honte à reconnaître des repas sautés	Sous-estimation
Composition de l'échantillon	68,0 % de femmes contre 56 %	Faible surestimation, corrigée par le redressement (33,1 %)

Le sens global de l'erreur est donc incertain : on présente la prévalence comme un **ordre de grandeur**, avec ses limites.

Partie C – Veille

Question 8 – Organiser une veille (2 pts)

Thème	Sources fiables	Outils	Fréquence
Protection des données	CNIL (fiches pratiques, référentiels, sanctions) ; Comité européen de la protection des données (lignes directrices) ; délégué à la protection des données de l'université	Lettre d'information de la CNIL, flux RSS	Mensuelle
Éthique de la recherche	Textes de la loi Jardé (Légifrance) ; comité d'éthique de l'université ; Comité consultatif national d'éthique	Alertes Légifrance, site du CCNE	Trimestrielle
Précarité alimentaire étudiante	Observatoire national de la vie étudiante (enquêtes « Conditions de vie des étudiants ») ; CNOUS et réseau des CROUS ; rapports parlementaires ; Santé publique France	Alertes de moteur de recherche, sites institutionnels	Trimestrielle
Aide alimentaire et dignité	Rapports du Conseil national de l'alimentation ; associations d'aide alimentaire ; recherche en sciences sociales (Cairn, HAL)	Alertes bibliographiques	Semestrielle

Diffusion : une fiche de veille d'une page, datée, pour l'équipe du service de santé et les étudiants relais, et un point de dix minutes à la réunion mensuelle ; les sources sont classées par date et par niveau de fiabilité.

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique

Question 9 – Trois situations (1,5 pt)

- **Liste des répondants ayant un score de 5 ou 6** : l'enquête de mars ne devait pas permettre d'identifier les répondants ; si les adresses ont été collectées, les utiliser pour appeler les étudiants serait un **détournement de finalité** (article 5 du RGPD), une atteinte à la vie privée et une démarche **stigmatisante**. Réponse : « Je comprends votre souci d'aider ces étudiants, mais je ne peux pas utiliser les réponses d'une enquête pour contacter des personnes qui ne l'ont pas demandé. Je propose plutôt d'écrire à tous les étudiants pour présenter les aides, et d'ajouter au prochain questionnaire une case facultative "je souhaite être recontacté", dans un formulaire séparé. »
- **Vidéo de la distribution** : filmer des étudiants identifiables qui viennent chercher un panier porte atteinte à leur **droit à l'image** (article 9 du Code civil) et révèle leur situation sociale ; si la vidéo valorise une marque, il s'agit en outre d'influence commerciale (loi du 9 juin 2023). Réponse : « Merci de votre envie d'aider. Nous ne filmerons pas les étudiants qui viennent chercher un panier. Si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser une vidéo sur les aides du campus, avec des étudiants volontaires qui acceptent par écrit d'apparaître, sans les associer à la précarité. »
- **Réutilisation du fichier pour un article scientifique** : la finalité annoncée aux répondants était l'adaptation des aides, pas la recherche ; une réutilisation suppose de vérifier la **compatibilité des finalités**, d'informer les personnes, d'obtenir l'accord du **délégué à la protection des données** et, selon les règles de l'université, l'avis de son **comité d'éthique**. Une enquête sociologique de ce type ne relève pas, a priori, de la loi Jardé, qui concerne les recherches visant le développement des connaissances biologiques ou médicales ; elle reste soumise au RGPD. Réponse : « Je transmets votre demande au délégué à la protection des données et à la responsable du service ; si elle est acceptée, seules des données anonymisées pourront vous être communiquées. »

Question 10 – Campagne, trame de l'exposé et questions du jury (1,5 pt)

Campagne : un message universel et positif (« Bien manger à la fac, c'est pour tout le monde : repas à 1 €, épicerie, ateliers, bons fruits et légumes ») plutôt qu'un message sur la « précarité » ; affiches dans tous les bâtiments, y compris les toilettes et les ascenseurs (lecture discrète) ; carte avec un QR code vers une page

unique des aides ; messages des étudiants relais sur les réseaux de l'université ; vidéos courtes où des étudiants volontaires présentent une recette en dix minutes. Aucun visuel associant un étudiant identifiable à la pauvreté.

Trame de l'exposé (10 minutes) : 1 min, contexte et demande ; 2 min, diagnostic chiffré (34,2 % d'insécurité, 33,1 % après redressement, RR 1,74, non-recours) ; 2 min, analyse éthique (questionnaire et RGPD, proposition de l'enseigne) ; 2 min, objectifs et plan d'action ; 1 min, ce que j'ai réalisé (questionnaire corrigé, un atelier) ; 1 min, évaluation et limites ; 1 min, conclusion et perspectives.

Questions probables du jury : 1. Qu'est-ce qu'une donnée de santé au sens du RGPD ? 2. Pourquoi une case pré-cochée ne vaut-elle pas consentement ? 3. Qu'est-ce qu'une AIPD et quand est-elle obligatoire ? 4. Quelle différence entre anonymisation et pseudonymisation ? 5. Pourquoi avoir refusé les menus gratuits ? 6. Un partenariat avec une entreprise est-il toujours interdit ? 7. Comment avez-vous évité de stigmatiser les étudiants ? 8. Votre échantillon est-il représentatif ? 9. Pourquoi redresser selon le sexe ? 10. Que signifie votre RR de 1,74 ? 11. La bourse est-elle la cause de l'insécurité alimentaire ? 12. Qu'avez-vous répondu au vice-président ? 13. Votre enquête relève-t-elle de la loi Jardé ? 14. Comment avez-vous travaillé avec les étudiants relais ? 15. Comment évaluerez-vous la baisse du non-recours ?

Barème – Barème du temps 1

Partie A : 9 points (indicateurs et diagnostic 2 ; questionnaire et RGPD 2 ; analyse éthique et conflit d'intérêts 2 ; objectifs 1,5 ; plan et budget 1,5). Partie B : 3 points. Partie C : 2 points. Partie D : 3 points. Expression, vocabulaire et sources datées : 3 points. Total : 20 points.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Accepter de transmettre ou d'utiliser une liste nominative « pour aider » ; croire qu'un questionnaire devient conforme parce qu'il comporte une case de consentement ; confondre pseudonymisation et anonymisation ; oublier la conservation et l'hébergement des données ; refuser toute relation avec une entreprise sans proposer d'alternative, ou au contraire accepter le logo sur une campagne de santé ; présenter le RR comme une preuve que « la bourse cause la faim » ; ne pas discuter les biais d'un questionnaire en ligne volontaire.

Corrigé S2 – « Cuisiner sans alcool, et sans être jugé » : un atelier culinaire en soins de réadaptation en addictologie

> **que le jury attend**
>
> Le jury évalue la rigueur technique (bon de commande, fiche technique, calculs, hygiène) et, sur ce sujet, la qualité du **cadre éthique** : non-jugement, confidentialité, respect du projet de soins, refus de tout produit contenant de l'alcool, limites de la relation professionnelle. Il valorise les adaptations individualisées présentées sans désigner les personnes devant le groupe et une animation qui redonne confiance (« faire avec » plutôt que « faire à la place »). Il pénalise l'oubli de l'allergie à l'œuf, l'usage d'un extrait de vanille alcoolisé, la promesse de garder un secret qui concerne la sécurité du patient et les photos de patients.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Besoins, ressources et objectifs (2 pts)

Besoins	Ressources
Reprendre confiance dans sa capacité à cuisiner (trois patients n'ont pas cuisiné depuis des années)	Souvenirs de recettes, savoir-faire anciens à faire revivre
Retrouver le plaisir de manger sans alcool ; gérer les envies de sucré	Motivation liée au projet de soins ; cadre sécurisant de la clinique
Rompre l'isolement : plusieurs vivent seuls	Dynamique de groupe, entraide entre patients
Besoins de santé : sel (M. G.), dénutrition (Mme F.), envies de sucré (M. T.), mémoire et tremblements (M. B.), allergie à l'œuf (M. R.), pas de viande (Mme L.)	Infirmière présente ; diététicienne du service pour le suivi
Petit budget et équipement limité au retour à domicile	Recette économique, faisable avec une plaque

Objectif général : permettre aux patients de reprendre confiance en leur capacité à préparer un repas simple, équilibré et économique, et de retrouver le plaisir de manger sans alcool, dans un cadre bienveillant.

Objectifs opérationnels : à la fin de l'atelier, chaque participant sera capable de **réaliser** avec son binôme une étape de la recette (façonner les boulettes, préparer la sauce, cuire le boulgour ou les courgettes, pocher les poires) ; de **citer** une façon de remplacer le vin ou l'alcool dans une recette ; de **dire** s'il se sent capable de refaire ce repas chez lui, sur une échelle de 1 à 5, avec une progression d'au moins 1 point par rapport au début.

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Denrée	Net pour 10	Perte	Brut pour 10	Unité de commande	Coût
Bœuf haché à 5 % MG	1 000 g	0 %	1 000 g	1 kg	1 × 12,50 = 12,50 €
Chapelure	80 g	0 %	80 g	0,08 kg	0,08 × 3,20 = 0,26 €
Œufs	2 œufs	0 %	2 œufs	2 pièces	2 × 0,30 = 0,60 €
Oignons	300 g	10 %	300 / 0,9 = 333 g	0,333 kg	0,333 × 1,80 = 0,60 €
Persil frais	30 g	20 %	30 / 0,8 = 37,5 g	0,0375 kg	0,0375 × 20,00 = 0,75 €
Tomates pelées au jus	1 200 g	0 %	1 200 g	3 boîtes de 400 g	1,2 × 1,60 = 1,92 €
Huile d'olive	80 g	0 %	80 g	0,08 kg	0,08 × 8,50 = 0,68 €
Boulgour	600 g	0 %	600 g	0,6 kg	0,6 × 3,00 = 1,80 €
Courgettes	1 500 g	10 %	1 500 / 0,9 = 1 667 g	1,667 kg	1,667 × 2,40 = 4,00 €
Poires	1 500 g	20 %	1 500 / 0,8 = 1 875 g	1,875 kg	1,875 × 2,80 = 5,25 €
Jus d'orange pur jus	600 g	0 %	600 g	0,6 L	0,6 × 1,90 = 1,14 €

Denrée	Net pour 10	Perte	Brut pour 10	Unité de commande	Coût
Épices, aromates, gousse de vanille	–	–	–	forfait	1,00 €
Total					**30,50 €**

Coût par portion : 30,50 / 10 = **3,05 €**, inférieur au budget de 3,20 € : le budget est respecté, avec une marge de 0,15 € par portion (1,50 € au total), utilisable pour l'enrichissement de Madame F. Le bœuf représente 12,50 / 30,50 = **41 %** du coût.

Question 3 – Fiche technique, adaptation de la recette et adaptations individuelles (3 pts)

Fiche technique – Boulettes de bœuf à la sauce tomate, boulgour, courgettes sautées (10 portions)

Ingrédients : bœuf haché 1 kg ; chapelure 80 g ; 2 œufs ; oignons 333 g bruts ; persil 37,5 g brut ; ail, cumin, thym, poivre ; tomates pelées au jus 1,2 kg ; huile d'olive 80 g ; boulgour 600 g ; courgettes 1,667 kg brutes ; sel ajouté en fin de cuisson, à part pour M. G.

Matériel : 4 planches (dont une réservée à la viande crue, de couleur différente), couteaux comptés, 2 saladiers, 2 sauteuses, 1 casserole, 1 plaque de cuisson pour le four, thermomètre à sonde, balance, verre doseur.

Étapes : 1. Laver les légumes ; éplucher et ciseler les oignons ; ciseler le persil. 2. Mélanger bœuf, chapelure, œufs, la moitié des oignons, persil, ail et cumin ; façonner 40 boulettes de 30 g environ (4 par personne). 3. Faire revenir le reste des oignons dans 30 g d'huile, ajouter les tomates et le thym, laisser mijoter 15 minutes. 4. Dorer les boulettes au four à 200 °C pendant 12 minutes, puis les terminer 10 minutes dans la sauce ; vérifier la température à cœur. 5. Cuire le boulgour dans 1,5 fois son volume d'eau, 10 à 12 minutes à couvert. 6. Couper les courgettes en demi-rondelles, les sauter 6 à 8 minutes dans le reste de l'huile, avec ail et thym.

Points critiques : viande hachée conservée à moins de 2 °C jusqu'à l'utilisation ; lavage des mains et du matériel après manipulation de la viande crue ; cuisson à cœur sans trace rosée, au moins 70 °C au thermomètre ; préparation des boulettes sans œuf pour M. R. **en premier**, avec du matériel propre ; maintien au chaud au-dessus de 63 °C jusqu'au service.

Fiche technique – Poires pochées au jus d'orange et à la cannelle (10 portions)

Ingrédients : poires 1,875 kg brutes ; jus d'orange 600 g ; 400 g d'eau ; cannelle (5 g) ; une gousse de vanille fendue ; une étoile de badiane (facultative).

Étapes : 1. Éplucher les poires (ou les laver et les garder avec la peau pour plus de fibres), les couper en deux et retirer le cœur. 2. Porter le jus, l'eau, la cannelle et la vanille à frémissement. 3. Pocher les poires 15 à 20 minutes à couvert, à frémissement ; vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau. 4. Retirer les poires, réduire le liquide de moitié et napper. Servir tiède ou froid.

Points critiques : liquide chaud (brûlures) ; refroidissement rapide si le dessert est servi froid.

Recette du document 5	Adaptation	Justification
75 cL de vin rouge	Jus d'orange et eau (600 g + 400 g pour 10 portions)	Règle de l'établissement ; une partie de l'alcool persiste à la cuisson ; le goût et l'odeur du vin peuvent réveiller l'envie de boire
Extrait de vanille alcoolisé	Gousse de vanille	Même règle ; les extraits liquides contiennent souvent de l'alcool
150 g de sucre	Supprimé	Le jus et les poires apportent un goût sucré suffisant ; on limite les sucres ajoutés, en particulier pour M. T.

Recette du document 5	Adaptation	Justification
Boule de glace	Supprimée ou remplacée par une cuillerée de fromage blanc	Coût, sucres ajoutés ; le fromage blanc enrichit le dessert de Madame F.
Badiane	Conservée (facultative)	Épice sans alcool qui donne du parfum

Patient	Adaptation (préparée sans le désigner devant le groupe)
M. G. (hypertension)	Pas de sel ajouté dans sa portion : le sel est ajouté à la fin pour les autres ; goût apporté par l'ail, le cumin, le thym, le persil et le citron ; conseil pour la maison : tomates en conserve sans sel ajouté
Madame F. (dénutrition)	Enrichissement : 10 g de lait en poudre écrémé dans sa sauce, 5 g d'huile d'olive supplémentaires sur les légumes, 100 g de fromage blanc avec les poires : environ **+ 157 kcal** et **+ 10,8 g de protéines** ; portion complète de boulgour ; fractionnement conseillé (collation)
M. T. (envies de sucré)	Dessert sans sucre ajouté, poire avec la peau (fibres) ; échange sur les envies de sucré, fréquentes après le sevrage, sans interdit ni culpabilisation ; idées de collations (fruit, yaourt, pain et fromage)
M. R. (allergie à l'œuf)	Boulettes sans œuf (liaison avec la chapelure humidifiée d'un peu de sauce tomate), préparées en premier, cuites sur une plaque séparée et identifiées ; vérification de l'étiquette de la chapelure (traces d'œuf)
Madame L. (pas de viande)	Deux œufs pochés dans la sauce tomate, ou boulettes de pois chiches et de chapelure ; même accompagnement

Version « à refaire chez soi » avec une plaque : boulettes dorées à la poêle avec un filet d'huile, puis sauce tomate ajoutée dans la même poêle avec les courgettes en dés ; boulgour versé dans de l'eau bouillante, hors du feu, à couvert (10 minutes) ; poires pochées dans une petite casserole ou remplacées par une poire crue. Astuces petit budget : bœuf haché surgelé, tomates en conserve, courgettes surgelées hors saison, boulgour acheté en paquet d'un kilogramme ; recette pour deux personnes, avec une portion à congeler.

Question 4 – Apports d'une portion (2 pts)

Composant	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Plat (boulettes, sauce, boulgour, courgettes)	517,5	34,15	54,13	7,73	15,53	11,15	0,32	5,81	47,13
Dessert (poire, jus d'orange, cannelle)	113,4	0,93	24,35	20,40	0,48	4,78	0,01	0,19	28,67
Repas	**630,9**	**35,08**	**78,49**	**28,13**	**16,01**	**15,93**	**0,33**	**6,00**	**75,80**

Calcul posé – Exemples de calcul et répartition de l'énergie

- Bœuf : 100 × 130 / 100 = 130 kcal ; 100 × 21,9 / 100 = 21,90 g de protéines. Boulgour : 60 × 347 / 100 = 208,2 kcal ; 60 × 10,5 / 100 = 6,30 g de fibres. Courgettes : 150 × 17,9 / 100 = 26,85 mg de vitamine C.
- Protéines : 35,08 × 4 / 630,9 = **22,2 %** de l'énergie ; glucides : 78,49 × 4 / 630,9 = **49,8 %** ; lipides : 16,01 × 9 / 630,9 = **22,8 %**.
- Sucres libres : seuls les sucres du jus d'orange (5,77 g) en font partie, soit 5,77 × 4 / 630,9 = **3,7 %** de l'énergie du repas ; les sucres des poires et des légumes ne sont pas des sucres libres.
- Madame F. avec enrichissement : 630,9 + 156,8 = **787,6 kcal** et 35,08 + 10,82 = **45,9 g** de protéines.

Commentaire. Le repas apporte environ 630 kcal, soit un déjeuner complet pour un adulte. Les protéines sont abondantes (35 g), les lipides modérés (22,8 % de l'énergie) et les glucides viennent surtout du boulgour et des

fruits. Les **fibres** (15,9 g) couvrent plus de la moitié du repère de 30 g par jour, grâce au boulgour, aux légumes et à la poire. Le **fer** (6 mg, surtout héminique grâce au bœuf) et la **vitamine C** (75,8 mg) sont élevés, ce qui intéresse des personnes dont l'alimentation a souvent été déséquilibrée. Le **sel** apporté par les aliments est faible (0,33 g) : l'essentiel dépend du sel ajouté, ce qui permet d'adapter facilement la portion de M. G. Les **sucres libres** ne représentent que 3,7 % de l'énergie, sous le seuil idéal de 5 % de l'OMS : le dessert reste sucré au goût sans sucre ajouté, une piste concrète pour M. T. Pour **Madame F.**, l'enrichissement porte le repas à près de 790 kcal et 46 g de protéines, sans augmenter le volume de l'assiette, ce qui est important quand l'appétit est faible.

Question 5 – Cadre éthique de l'atelier (2 pts)

> **Exemple – Le cadre énoncé au début de l'atelier**
>
> « Bienvenue. Ici, on cuisine ensemble, à son rythme. Personne n'est obligé de parler de soi, ni de goûter ce qu'il ne veut pas. Ce qui se dit dans l'atelier reste dans l'atelier : on ne le répète pas dehors. On ne juge ni ce que les autres mangent, ni leur façon de cuisiner. Pas de photo de personnes pendant l'atelier. Si quelqu'un ne se sent pas bien, il peut faire une pause avec l'infirmière. »

- **Consentement** : la participation est libre ; chacun peut refuser une tâche, ne pas goûter ou quitter l'atelier sans conséquence sur ses soins.
- **Non-jugement** : on ne questionne pas les consommations passées ; on parle de goûts, de souvenirs, de projets ; on valorise chaque réussite ; on évite les mots stigmatisants (« alcoolique », « rechute ») et on parle de « personnes » plutôt que de « malades ».
- **Respect du projet de soins** : aucun produit contenant de l'alcool, pas de boisson imitant une boisson alcoolisée ; les adaptations médicales (sel, enrichissement, allergie) sont appliquées discrètement.
- **Droit à l'image et confidentialité** : la présence dans une clinique d'addictologie est une **donnée de santé** ; une photo identifiable révélerait cette information (article 9 du Code civil, RGPD). Seules des photos de plats ou de mains, sans signe distinctif, peuvent être prises, avec l'accord des participants.
- **Secret partagé** : le stagiaire fait partie de l'équipe ; une information utile à la sécurité d'un patient est transmise à l'équipe, dans la limite du nécessaire, en informant le patient (article L. 1110-4 du Code de la santé publique).
- **Limites de la relation** : pas d'échange de coordonnées personnelles, pas de relation sur les réseaux sociaux ; les liens après la sortie passent par la structure.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté des 3 heures (2 pts)

Horaire	Candidat	Participants
8 h 45 – 9 h 05	Lecture du sujet, organisation, vérification des denrées et des étiquettes (allergènes)	–
9 h 05 – 9 h 30	Mise en place des 4 postes, comptage des couteaux avec l'infirmière, pesée, imagier de la recette affiché	–
9 h 30 – 9 h 45	Accueil, tour de prénoms, cadre de l'atelier, échelle de confiance de 1 à 5	Écoute, présentation volontaire
9 h 45 – 9 h 55	Démonstration : façonner une boulette, couper une courgette en sécurité	Observation, questions
9 h 55 – 10 h 30	Animation des binômes ; boulettes sans œuf de M. R. en premier	Binôme 1 : boulettes ; binôme 2 : sauce tomate ; binôme 3 : courgettes ; binôme 4 : poires pochées
10 h 30 – 10 h 40	Surveillance des cuissons ; contrôle à cœur	Pause, possibilité de pause tabac encadrée par l'infirmière

Horaire	Candidat	Participants
10 h 40 – 11 h 00	Cuisson du boulgour, finition, adaptations individuelles	Boulgour, dressage d'une assiette témoin
11 h 00 – 11 h 25	Dégustation conviviale, échange sur le goût, les souvenirs, le plaisir de manger	Dégustation, grille
11 h 25 – 11 h 40	Rangement avec les participants, comptage final des couteaux	Vaisselle, rangement, tri des déchets
11 h 40 – 11 h 45	Évaluation, « faire dire », remise de la fiche recette imagée	Échelle de confiance, une phrase « ce que je refais chez moi »

Binômes : M. B. (mémoire, tremblements) est associé à un patient à l'aise, sur une tâche sans couteau (façonnage des boulettes, mesure du boulgour) ; M. R. commence par ses propres boulettes, avec du matériel propre ; les patients qui n'ont pas cuisiné depuis longtemps sont associés à ceux qui se sentent plus à l'aise.

Question 7 – Méthodes, outils et grille de dégustation (1,5 pt)

- **Démonstration courte** suivie d'une réalisation en binômes : on fait **avec** les personnes, jamais à leur place.
- **Fiche recette imagée** (photos numérotées des étapes, quantités en mesures simples), utile pour M. B. et pour refaire la recette à la maison.
- **Échange sur les souvenirs et le plaisir** : « Quel plat vous rappelle un bon moment ? », « Quelles épices aimez-vous ? » ; le repas redevient un moment de lien plutôt qu'un sujet médical.
- **Comparaison de prix** : coût de la portion (3,05 €) comparé à un plat préparé du commerce.
- **« Faire dire »** en fin d'atelier : chacun dit une étape qu'il saurait refaire et une façon de remplacer le vin dans une recette.

Critère (cocher une case ; version imagée : trois visages)	J'aime beaucoup	J'aime un peu	Je n'aime pas
Aspect de l'assiette	( )	( )	( )
Odeur	( )	( )	( )
Goût des boulettes et de la sauce	( )	( )	( )
Goût des poires pochées	( )	( )	( )
Je referais ce repas chez moi	Oui	Peut-être	Non

Question 8 – Hygiène, sécurité, allergènes et éco-gestes (1,5 pt)

5 M	Danger	Mesure
Matière	Viande hachée (bactéries, dont *E. coli* producteurs de shigatoxines) ; œufs	Chaîne du froid (moins de 2 °C pour la viande hachée) ; cuisson à cœur, au moins 70 °C ; œufs extra-frais, non fêlés
Main-d'œuvre	Contamination par les mains	Lavage des mains à l'arrivée et après la viande crue ; tablier, cheveux attachés ; pas de bijoux
Matériel	Contamination croisée ; coupures	Planche réservée à la viande crue ; couteaux comptés au début et à la fin ; planches antidérapantes
Milieu	Plans de travail souillés	Nettoyage et désinfection avant et après ; poubelle à pédale
Méthode	Refroidissement lent, restes	Maintien au-dessus de 63 °C ou refroidissement de 63 °C à 10 °C en moins de 2 heures ; restes non distribués aux participants

Sécurité : manches des casseroles tournés vers l'intérieur ; liquide de pochage manipulé par le candidat ou avec une louche ; M. B. ne manipule ni couteau ni liquide bouillant ; gants de protection pour sortir les plaques du four. Allergènes : œufs (boulettes, sauf pour M. R.), gluten (boulgour, chapelure) ; affichage des allergènes de

chaque préparation (règlement INCO) ; boulettes de M. R. préparées en premier et identifiées. Éco-gestes : couvercle pendant les cuissons ; épluchures et parures au compost ; achat de légumes de saison (courgettes en été, poires en automne) ou surgelés hors saison ; quantités calculées pour éviter le gaspillage.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (3 pts)

Critères attendus : boulettes régulières (environ 30 g), dorées et cuites à cœur ; sauce nappante, assaisonnée ; boulgour égrené ; courgettes encore légèrement fermes ; poires tendres, nappées de jus réduit ; assiette dressée avec les trois composantes séparées et le persil ; respect des quantités, des températures et de l'organisation ; plan de travail propre en continu.

Question 10 – Évaluation et trois situations (1 pt)

Évaluation : échelle de confiance « je me sens capable de cuisiner ce repas seul » de 1 à 5, au début et à la fin (cible : + 1 point en moyenne) ; grille de dégustation ; « faire dire » d'une étape et d'un remplacement du vin ; question orale « allez-vous refaire ce plat ? » ; bilan avec la diététicienne et l'infirmière, sans information individuelle hors de l'équipe de soins.

- **Photos pour le site de la clinique** : refus des photos de patients identifiables (donnée de santé, droit à l'image) ; proposition de photos des plats, des mains ou de la cuisine vide. Réponse : « Je ne peux pas photographier les patients : leur présence ici est une information de santé. Je peux vous proposer des photos des plats et de l'atelier sans visage. »
- **Patient qui a bu pendant sa permission** : on ne promet pas un secret qui concerne la sécurité du patient et son projet de soins ; l'information est partagée avec l'équipe, dans la limite du nécessaire, en l'informant. Réponse : « Merci de votre confiance. Je ne vais pas en parler aux autres participants. Mais cette information est importante pour vos soins : je vous propose d'en parler vous-même à votre infirmière référente aujourd'hui, et je lui dirai que vous souhaitez la voir. Je ne peux pas la garder pour moi. »
- **Numéro de téléphone personnel** : refus bienveillant, qui protège la relation professionnelle. Réponse : « Cela me fait plaisir que vous ayez envie de cuisiner chez vous. Je ne donne pas mon numéro personnel, mais vous pouvez envoyer vos photos à l'équipe de la clinique ou les montrer lors de votre consultation de suivi avec la diététicienne. »

Barème – Barème du temps 2

Partie 1 : 11 points (besoins et objectifs 2 ; bon de commande 2 ; fiche technique, adaptation de la recette et adaptations individuelles 3 ; apports 2 ; cadre éthique 2). Partie 2 : 5 points (déroulé 2 ; méthodes et dégustation 1,5 ; hygiène, sécurité, allergènes, éco-gestes 1,5). Partie 3 : 4 points (réalisation 3 ; évaluation et situations 1). Total : 20 points.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Oublier les pertes des oignons, du persil, des courgettes et des poires ; conserver l'extrait de vanille ou proposer une « bière sans alcool » ; ajouter du sucre au dessert ; oublier les boulettes sans œuf ou les préparer après les autres avec le même matériel ; annoncer devant le groupe les pathologies des patients ; promettre au patient de garder le secret sur sa consommation ; accepter des photos de patients ou donner son numéro personnel ; faire à la place des participants.

Corrigé S3 – « Mon coach dit que sans poudre, je ne prendrai jamais de muscle » : compléments alimentaires, influence et éthique dans une salle de sport associative

que le jury attend

Le jury attend un diagnostic chiffré qui ne transforme pas le questionnaire SCOFF en diagnostic, une démonstration simple que l'alimentation courante suffit (protéines par kilogramme, coût au gramme de protéines), une analyse nuancée de l'offre de la marque et des réponses claires aux demandes qui dépassent le cadre professionnel. Il valorise le travail **avec** les coachs plutôt que contre eux, et des messages positifs, sans culpabiliser ni moraliser. Il pénalise l'acceptation d'un « plan de sèche » rédigé au nom d'un autre, l'apparition du stagiaire dans une publicité et les affirmations non sourcées sur la dangerosité de tous les compléments.

Temps 1 – Le projet d'intervention

Question 1 – Indicateurs et diagnostic (2,5 pts)

Calcul posé – Indicateurs du questionnaire (n = 96)

- Taux de participation : 96 / 310 × 100 = **31,0 %**.
- Poudres de protéines au moins trois fois par semaine : 41 / 96 = **42,7 %** ; « brûleur de graisse » déjà utilisé : 12 / 96 = **12,5 %** ; repas sautés pour perdre du poids : 23 / 96 = **24,0 %**.
- Score SCOFF de 2 ou plus : 18 / 96 = **18,8 %**.
- Conseils venant surtout des réseaux sociaux : 52 / 96 = **54,2 %** ; d'un coach de la salle : 29 / 96 = **30,2 %**.

Niveau	Constats
Personnes	Usage fréquent de poudres (42,7 %) ; pratiques de restriction (24,0 % sautent un repas par jour) ; 18,8 % de repérages SCOFF positifs, qui justifient une orientation, pas un diagnostic ; faibles compétences culinaires (« je ne sais pas cuisiner ») ; budget alimentaire entamé par les poudres
Association	Un coach revend des produits (conflit d'intérêts) ; coachs bénévoles sans formation en nutrition ; aucun professionnel de santé ; offre de financement d'une marque
Environnement commercial et numérique	Influenceurs (54,2 % des adhérents s'informent surtout sur les réseaux sociaux) ; vente en ligne de « brûleurs » ; normes corporelles (« secs toute l'année »)

Diagnostic. Une partie importante des adhérents, jeunes et majoritairement masculins, suit des conseils commerciaux ou non qualifiés : usage régulier de compléments sans besoin démontré, restriction alimentaire et produits stimulants, avec des signes d'alerte de troubles du comportement alimentaire chez près d'un répondant sur cinq. L'association, sans le vouloir, entretient ces pratiques (revente par un coach, projet de partenariat). Les ressources sont réelles : une salle à petit prix fréquentée par des jeunes du quartier, des coachs écoutés, une motivation forte pour la santé et la performance, des partenaires de santé proches. Limite : 31 % de participation, sur un questionnaire déposé dans une urne ; les adhérents concernés ont pu répondre davantage ou, au contraire, éviter le sujet.

Question 2 – Protéines et coût au gramme (2,5 pts)

Calcul posé – Protéines de l'adhérent de 70 kg et coût des sources de protéines

- Poudre : 3 doses × 24 g = **72 g** de protéines par jour. Total : 105 + 72 = **177 g**, soit 177 / 70 = **2,53 g/kg/j**.

- Repères : référence nutritionnelle 0,83 × 70 = **58,1 g/j** ; limite haute des apports satisfaisants 2,2 × 70 = **154 g/j**. Les repas seuls apportent 105 / 70 = **1,50 g/kg/j**, déjà au-dessus de la référence.
- Coût de la poudre : 39,90 € / 1 000 g × 30 g = **1,20 €** par dose, soit 1,20 / 24 = **0,050 €** par gramme de protéines ; pour trois doses par jour pendant 30 jours : 3 × 30 × 30 g = 2,7 kg, soit 2,7 × 39,90 = **107,73 €** par mois.
- Filet de poulet : 11,50 € / 1 000 g × 100 g / 23,4 g = **0,049 €** par gramme de protéines.
- Haricots rouges en conserve : 2,40 € / 1 000 g × 100 g / 8,31 g = **0,029 €** par gramme.
- Lait demi-écrémé : 0,95 € / 1 000 g × 100 g / 3,48 g = **0,027 €** par gramme.

Conclusion. L'adhérent dépasse la limite haute des apports satisfaisants (2,53 contre 2,2 g/kg/j) alors que son alimentation couvre déjà largement ses besoins : la poudre n'apporte **rien d'utile** dans sa situation et lui coûte plus de 100 € par mois, l'équivalent d'une part importante d'un budget alimentaire étudiant (« j'en achète à la place des courses »). Au gramme de protéines, la poudre coûte autant que le poulet et près de deux fois plus que les haricots rouges ou le lait. Le message n'est pas « la poudre est dangereuse », mais « elle est inutile pour vous et chère ; ces protéines se trouvent dans des aliments courants, qui apportent en plus des fibres, du calcium, du fer et du plaisir ».

Question 3 – Analyse éthique et offre de la marque (2 pts)

- **Bienfaisance** : aider les adhérents à progresser et à rester en bonne santé est l'objectif commun du réseau et de l'association.
- **Non-malfaisance** : la restriction, les produits stimulants et les normes corporelles extrêmes exposent à des risques (troubles du comportement alimentaire, effets indésirables signalés en nutrivigilance) ; une « journée bilan » avec mesure de la masse grasse peut renforcer l'obsession du corps.
- **Autonomie** : les adhérents restent libres de leurs choix, à condition de recevoir une **information loyale**, indépendante des intérêts commerciaux.
- **Justice** : des jeunes au budget limité dépensent pour des produits inutiles ; l'association doit protéger les plus vulnérables.
- **Conflits d'intérêts** : le coach qui revend des poudres conseille ce qu'il vend ; la commission de 10 % lierait l'association aux ventes.
- **Allégations** : seules les allégations autorisées (règlement (CE) n° 1924/2006) sont possibles ; « brûleur de graisse » n'en fait pas partie, et un complément ne peut pas prétendre prévenir ou traiter une maladie.
- **Champ de compétence et orientation** : le « conseiller en nutrition sportive » n'a pas de titre protégé ; un repérage SCOFF positif conduit vers le médecin traitant ou la maison de santé, pas vers un programme de compléments.

Élément de l'offre	Analyse	Position proposée
8 000 € pour les vestiaires	Utile, mais crée une dépendance	Acceptable seulement en mécénat sans contrepartie commerciale, par convention écrite
Logo dans la salle et sur les tee-shirts des coachs	Les coachs deviennent des supports publicitaires	Refus
Distributeur de boissons protéinées et de barres	Banalise les produits ; environnement commercial	Refus ; préférer un point d'eau et une corbeille de fruits
Code de réduction et commission de 10 %	Conflit d'intérêts direct pour l'association	Refus
« Journée bilan » et programme de compléments	Mesure du corps sans cadre de santé, vente déguisée, hors champ de compétence	Refus

Réponse au président : « Le réseau de santé ne peut pas s'associer à une marque de compléments, et je vous déconseille d'accepter le logo, le distributeur, la commission et la journée bilan, qui feraient de vos coachs des

vendeurs. Si la marque souhaite soutenir l'association sans contrepartie, une convention de mécénat peut être étudiée par votre bureau. Je vous propose en parallèle une charte de la salle et une formation des coachs. »

Question 4 – Objectifs, plan d'action et budget (4 pts)

Objectif général : favoriser des pratiques alimentaires favorables à la santé et à la performance chez les adhérents de « Force et Quartier », en réduisant l'usage inutile de compléments et les pratiques de restriction, d'ici un an.

Objectif	Indicateur	Départ	Cible	Échéance
Spécifique 1 : réduire l'usage de compléments sans besoin démontré	Part des adhérents qui consomment des poudres au moins trois fois par semaine	42,7 %	30 %	12 mois
Spécifique 2 : réduire les pratiques de restriction et améliorer l'orientation	Part des adhérents qui sautent un repas par jour pour perdre du poids	24,0 %	15 %	12 mois
Opérationnel : former les six coachs	Coachs formés ; charte signée	0	6 ; charte adoptée	3 mois
Opérationnel : animer cinq ateliers culinaires	Ateliers, participants	0	5 ateliers, 40 participations	9 mois
Opérationnel : mettre en place un circuit d'orientation	Permanence mensuelle de la diététicienne de la maison de santé ; affiche des contacts	Non	Oui, 6 permanences	6 mois

Période	Action	Justification
Mois 1 à 3	Charte de la salle (pas de vente de compléments par les coachs, pas de conseil de régime, orientation vers un professionnel) adoptée en assemblée ; formation des coachs (repères, signes d'alerte, orientation)	Conflits d'intérêts, champ de compétence
Mois 2 à 9	Cinq ateliers « des protéines dans l'assiette » ; défi recettes en vidéo entre adhérents	Pairs, compétences culinaires
Mois 3 à 12	Permanence mensuelle de la diététicienne de la maison de santé ; affiche « Besoin d'en parler ? » avec les contacts	Orientation, non-stigmatisation
Mois 4	Atelier « décrypter une publicité ou une étiquette de complément »	Littératie critique, allégations
Mois 12	Nouveau questionnaire anonyme ; restitution aux adhérents	Évaluation

Poste	Calcul	Montant
Formation des coachs	2 séances × 3 h × 45 €	270 €
Permanences de la diététicienne	6 × 1 h × 45 €	270 €
Denrées des ateliers	5 ateliers × 10 portions × 2,90 €	145 €
Matériel (balance, boîtes de conservation, ustensiles)	Devis	200 €
Défi recettes en vidéo (lots non alimentaires, matériel)	Devis	150 €
Impression (charte, affiches, cartes)	Devis	120 €
Supports de l'atelier « décrypter »	Devis	80 €
Réserve pour imprévus	–	265 €
Total		**1 500 €**

Question 5 – Risque relatif, intervalle de confiance et taille d'échantillon (3 pts)

Calcul posé – SCOFF de 2 ou plus selon l'utilisation d'un « brûleur de graisse »

- Utilisateurs : 7 / 12 = **58,3 %** ; non-utilisateurs : 11 / 84 = **13,1 %**.
- RR = 0,5833 / 0,1310 = **4,45** ; ln RR = 1,4939.
- Erreur type = √(1/7 − 1/12 + 1/11 − 1/84) = √(0,1429 − 0,0833 + 0,0909 − 0,0119) = √0,1385 = **0,372**.
- IC 95 % = exp(1,4939 ± 1,96 × 0,372) = exp(0,7644) à exp(2,2234) = **[2,15 ; 9,24]**.
- Proportion de SCOFF positifs : 0,1875 ± 1,96 × √(0,1875 × 0,8125 / 96) = 0,1875 ± 0,0781 = **[10,9 % ; 26,6 %]**.
- Taille d'échantillon pour ± 5 points : n0 = $1{,}96^2 \times 0{,}1875 \times 0{,}8125 / 0{,}05^2$ = **234,1** ; corrigée pour 310 adhérents : 234,1 / (1 + 233,1 / 310) = **134** répondants.

Conclusion prudente. Les utilisateurs de « brûleurs » ont un repérage SCOFF positif 4,45 fois plus souvent que les autres, et l'intervalle ne contient pas 1 : l'association est statistiquement significative, mais très imprécise (intervalle large, seulement 12 utilisateurs). L'enquête est transversale : on ne sait pas si les produits favorisent les troubles ou si les personnes en difficulté avec leur alimentation recherchent ces produits ; le SCOFF n'est qu'un outil de repérage. La proportion de SCOFF positifs est connue à ± 7,8 points près ; pour atteindre ± 5 points, il faudrait 134 répondants, soit 38 de plus.

Question 6 – Veille (2 pts)

Thème	Sources	Outils	Fréquence
Compléments alimentaires et nutrivigilance	ANSES (avis, bilans de nutrivigilance) ; DGCCRF (enquêtes, alertes) ; site Rappel Conso	Lettres d'information, flux RSS, alertes	Mensuelle
Réglementation des allégations	Registre européen des allégations (Commission européenne) ; EFSA	Consultation du registre	À chaque support conçu
Influence commerciale	Textes officiels (Légifrance) ; DGCCRF (contrôles des influenceurs) ; Autorité de régulation professionnelle de la publicité	Alertes Légifrance	Trimestrielle
Nutrition du sportif et troubles du comportement alimentaire	HAS (recommandations sur l'anorexie mentale, 2010, et la boulimie, 2019) ; Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ; Fédération française anorexie boulimie	Alertes bibliographiques	Semestrielle

Diffusion : une fiche d'une page, datée, pour les coachs et le bureau de l'association ; un point de dix minutes à chaque réunion de coachs.

Question 7 – Deux situations et orientation (2 pts)

- **« Plan de sèche à 1 200 kcal » au nom du coach** : le stagiaire n'établit pas de régime individuel, encore moins au nom d'une autre personne ; 1 200 kcal pour un homme jeune et sportif est une restriction sévère, contraire au principe de non-malfaisance ; le coach n'a pas la qualification pour prescrire un régime. Réponse : « Je ne peux pas rédiger ce plan. Un régime aussi restrictif pour un jeune sportif présente des risques, et il doit être décidé avec un médecin ou une diététicienne qui le suit. Je peux proposer à cet adhérent un rendez-vous à la permanence de la maison de santé. »
- **Vidéo à côté des produits de la marque** : apparaître comme « la diététicienne d'accord » ferait du stagiaire et du réseau de santé les garants d'une marque, une atteinte à l'indépendance et à l'information loyale, contraire aux règles de l'influence commerciale (loi du 9 juin 2023) et à l'identité numérique professionnelle. Réponse : « Je ne peux pas apparaître à côté de produits commerciaux. Je peux en revanche enregistrer une courte vidéo sur une recette de l'atelier, sans marque, si le réseau de santé l'accepte. »

Repérer et orienter sans stigmatiser : les coachs sont formés à reconnaître des signaux (perte de poids rapide, entraînement compulsif, refus de manger devant les autres, propos dévalorisants sur le corps) ; ils en parlent en privé, avec bienveillance, en partant de ce que la personne ressent (« Je te trouve fatigué en ce moment, comment ça va ? ») et non de son poids ; ils proposent une orientation vers le médecin traitant ou la permanence de la maison de santé, et affichent les ressources d'aide ; ils ne commentent jamais le corps d'un adhérent devant les autres, ne pèsent personne en public et n'imposent rien. Le résultat individuel du SCOFF n'est jamais connu de la salle, puisque le questionnaire est anonyme.

Temps 2 – L'atelier culinaire « Des protéines dans l'assiette, pas dans le shaker »

Question 8 – Besoins et objectifs (2 pts)

Besoins : savoir préparer rapidement un repas complet et une collation à emporter ; comprendre que les protéines se trouvent dans des aliments courants et peu chers ; manger suffisamment au lieu de sauter des repas ; adapter pour l'intolérance au lactose et la consommation halal. Ressources : motivation pour la performance, esprit de défi, entraide.

Objectif général : rendre les adhérents capables de préparer en moins de 20 minutes un repas et une collation qui couvrent leurs besoins sans compléments, avec un petit budget.

Objectifs opérationnels : à la fin de l'atelier, chaque participant sera capable de **réaliser** un wrap complet et un pain perdu au four ; de **calculer** le coût d'un gramme de protéines de deux aliments à partir de l'étiquette et du prix ; de **citer** trois sources de protéines peu chères (légumes secs, œufs, lait ou yaourt).

Question 9 – Bon de commande, coût et apports (4 pts)

Denrée	Net pour 10	Perte	Brut pour 10	Unité	Coût
Tortillas de blé	20 tortillas	0 %	20	20 pièces	20 × 0,24 = 4,80 €
Filet de poulet	900 g	0 %	900 g	0,9 kg	0,9 × 11,50 = 10,35 €
Haricots rouges égouttés	600 g	0 %	600 g	0,6 kg	0,6 × 2,40 = 1,44 €
Maïs égoutté	300 g	0 %	300 g	0,3 kg	0,3 × 3,00 = 0,90 €
Carottes	500 g	15 %	500 / 0,85 = 588 g	0,588 kg	0,588 × 1,40 = 0,82 €
Laitue	200 g	25 %	200 / 0,75 = 267 g	0,267 kg	0,267 × 4,00 = 1,07 €
Yaourt nature	400 g	0 %	400 g	0,4 kg	0,4 × 2,20 = 0,88 €
Huile d'olive	50 g	0 %	50 g	0,05 kg	0,05 × 8,50 = 0,43 €
Pain complet rassis	500 g	0 %	500 g	0,5 kg	0,5 × 3,80 = 1,90 €
Lait demi-écrémé	800 g	0 %	800 g	0,8 L	0,8 × 0,95 = 0,76 €
Œufs	5 œufs	0 %	5	5 pièces	5 × 0,30 = 1,50 €
Pommes	1 000 g	15 %	1 000 / 0,85 = 1 176 g	1,176 kg	1,176 × 2,30 = 2,71 €
Sucre	50 g	0 %	50 g	0,05 kg	0,05 × 1,20 = 0,06 €
Épices, citron, aromates	–	–	–	forfait	0,80 €
Total					**28,41 €**

Coût par portion : 28,41 / 10 = **2,84 €** ≤ 2,90 € : budget respecté.

Composant	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)
Wraps (2 tortillas et garniture)	534,3	35,46	60,22	7,18	14,13	9,11	1,92	160,6	2,13
Pain perdu aux pommes	265,3	10,58	41,34	20,78	4,81	5,32	0,74	168,1	1,58

Composant	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)
Total	**799,7**	**46,04**	**101,56**	**27,96**	**18,94**	**14,43**	**2,65**	**328,8**	**3,71**

Calcul posé – Répartition de l'énergie et protéines par kilogramme

- Protéines : 46,04 × 4 / 799,7 = **23,0 %** ; glucides : 101,56 × 4 / 799,7 = **50,8 %** ; lipides : 18,94 × 9 / 799,7 = **21,3 %**.
- Pour un adhérent de 70 kg : 46,04 / 70 = **0,66 g/kg**, soit 46,04 / 58,1 = **79 %** de la référence journalière avec un seul repas et une collation.
- Sucres ajoutés : 5 g de sucre par portion, soit 5 × 4 / 799,7 = **2,5 %** de l'énergie.

Commentaire. Le repas et la collation apportent près de 800 kcal et 46 g de protéines, sans aucun complément : avec les autres repas de la journée, la référence de 58 g est largement dépassée, et l'apport reste dans l'intervalle satisfaisant. Les glucides (50,8 % de l'énergie) sont utiles à l'entraînement et à la récupération. Les fibres (14,4 g) et le calcium (329 mg) sont intéressants. Le point faible est le **sel** (2,65 g, soit plus de la moitié de la valeur de 5 g par jour recommandée par l'OMS), apporté surtout par les tortillas et le pain : on peut ne pas saler la garniture et préparer des galettes maison lors d'un prochain atelier.

Question 10 – Fiches techniques, version rapide et adaptations (4 pts)

Fiche technique – Wraps au poulet, haricots rouges, maïs et crudités, sauce au yaourt (10 portions)

Étapes : 1. Couper le poulet en lanières ; le saisir 6 à 8 minutes dans l'huile avec paprika, cumin et ail, jusqu'à cuisson à cœur. 2. Rincer et égoutter haricots et maïs. 3. Râper les carottes ; laver et émincer la laitue. 4. Sauce : yaourt, citron, ail, poivre. 5. Tiédir les tortillas 20 secondes à la poêle ; garnir, rouler serré, couper en deux.

Points critiques : volaille crue (planche dédiée, lavage des mains, cuisson à cœur) ; refroidissement rapide des restes.

Fiche technique – Pain perdu aux pommes et à la cannelle, cuit au four (10 portions)

Étapes : 1. Préchauffer le four à 180 °C. 2. Battre 5 œufs, 800 g de lait, 50 g de sucre et la cannelle. 3. Couper le pain rassis en tranches, les tremper rapidement. 4. Disposer dans un plat avec les pommes en lamelles. 5. Cuire 25 minutes ; laisser refroidir, couper en parts et mettre en boîte.

Points critiques : œufs (cuisson complète, pas de pâte crue goûtée) ; refroidissement rapide et conservation au froid jusqu'au lendemain.

Version « en moins de 20 minutes » chez soi : poulet remplacé par des œufs brouillés ou du thon au naturel les jours de manque de temps ; haricots et maïs en conserve ; carottes râpées achetées prêtes ; pain perdu cuit à la poêle, 3 minutes par face. Adaptations : **Sarah** tolère le yaourt (sauce) ; pour le pain perdu, lait sans lactose ou boisson végétale enrichie en calcium ; **adhérent végétarien** : poulet remplacé par une double portion de haricots rouges et un œuf dur, ou par du tofu poêlé ; le repas reste riche en protéines.

Question 11 – Déroulé, méthodes et posture (4 pts)

Horaire	Candidat	Participants
17 h 30 – 17 h 50	Lecture du sujet, organisation, vérification des denrées et des étiquettes	–
17 h 50 – 18 h 30	Mise en place des postes, pesées, affichage des prix au gramme de protéines	–
18 h 30 – 18 h 40	Accueil, cadre (pas de jugement sur le corps ni sur les pratiques), quiz rapide « vrai ou faux »	Réponses au quiz

Horaire	Candidat	Participants
18 h 40 – 18 h 50	Démonstration du roulage d'un wrap et du trempage du pain	Observation
18 h 50 – 19 h 35	Défi en binômes : un binôme chronomètre son wrap, les autres préparent garniture et pain perdu	Réalisation
19 h 35 – 19 h 50	Calcul en binômes du coût au gramme de protéines (poudre, poulet, haricots, lait)	Calcul, comparaison
19 h 50 – 20 h 15	Dégustation, échange sur la récupération, les réseaux sociaux, la « sèche »	Dégustation, grille
20 h 15 – 20 h 30	Rangement, mise en boîte de la collation, évaluation, « faire dire »	Rangement, évaluation

Méthodes : démonstration courte, défi chronométré (un wrap complet en moins de 10 minutes), calcul du coût au gramme de protéines à partir de vraies étiquettes, « faire dire » de trois sources de protéines peu chères. Grille de dégustation : goût, texture, « je le refais » (oui, peut-être, non), « je l'emporte à la salle » (oui, non). Posture sur les compléments et la « sèche » : partir des questions des participants ; donner des informations sourcées sans interdire (« dans ta situation, la poudre n'apporte pas plus que ce repas, et elle coûte plus cher ») ; ne jamais commenter le corps de quelqu'un ; rappeler que l'on peut parler en privé et présenter la permanence de la maison de santé.

Question 12 – Hygiène, allergènes et éco-gestes (3 pts)

5 M : **matière** (poulet conservé au froid jusqu'à l'utilisation, cuit à cœur ; œufs non fêlés ; conserves non bombées) ; **main-d'œuvre** (lavage des mains, notamment après le poulet cru et les œufs) ; **matériel** (planche réservée à la volaille, thermomètre) ; **milieu** (plans désinfectés, marche en avant) ; **méthode** (collation refroidie rapidement, boîtes fermées et étiquetées, transport dans un sac isotherme avec un pain de glace, consommation dans les 24 heures). Allergènes : gluten (tortillas, pain), œufs, lait (yaourt, lait) ; tableau affiché ; question orale à chacun. Éco-gestes : pain rassis valorisé, épluchures au compost, boîtes réutilisables plutôt que film plastique, cuisson du pain perdu pendant la préparation des wraps (four utilisé une seule fois).

Question 13 – Réalisation et évaluation (3 pts)

Réalisation attendue : wraps bien roulés, garniture répartie, poulet cuit à cœur et juteux ; pain perdu doré, moelleux, pommes fondantes ; présentation soignée et collation conditionnée. Évaluation : grille de dégustation ; « faire dire » ; nombre de participants capables de réaliser seuls un wrap en moins de 10 minutes ; intention de refaire ; à un mois, court questionnaire anonyme sur la fréquence d'usage des poudres et des repas sautés, comparé au questionnaire initial.

Barème – Barème

Temps 1 : indicateurs et diagnostic 2,5 ; protéines et coût au gramme 2,5 ; analyse éthique et offre de la marque 2 ; objectifs, plan et budget 4 ; recherche appliquée 3 ; veille 2 ; situations et orientation 2 ; expression 2 ; total 20. Temps 2 : besoins et objectifs 2 ; bon de commande et apports 4 ; fiches techniques et adaptations 4 ; déroulé, méthodes et posture 4 ; hygiène 3 ; réalisation et évaluation 3 ; total 20.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Présenter un score SCOFF positif comme un diagnostic de trouble du comportement alimentaire ; affirmer que tous les compléments sont dangereux, sans source ; oublier de comparer l'apport en protéines à la référence et à la limite haute ; accepter une partie de l'offre commerciale sans encadrement écrit ; rédiger le plan de sèche ou apparaître dans la vidéo ; oublier le transport au froid de la collation ; oublier le lactose pour Sarah ou proposer un poulet non halal à des participants qui mangent halal.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Ce que je sais faire	Sujet	Acquis	En cours	À retravailler
C3.1	Calculer et interpréter des prévalences ; redresser une prévalence selon la composition d'une population	S1, S3			
C3.1	Distinguer ce qui relève des personnes, des structures et de l'environnement dans un diagnostic	S1, S3			
C3.1	Analyser un questionnaire au regard du RGPD et rédiger une mention d'information	S1			
C3.1	Analyser une offre de partenariat avec la grille des conflits d'intérêts	S1, S3			
C3.1	Formuler des objectifs avec indicateur, cible et échéance ; construire un budget	S1, S3			
C3.2	Établir un bon de commande avec quantités brutes et nettes et vérifier un budget	S2, S3			
C3.2	Calculer des apports avec la table Ciqual 2025 et la part des sucres libres	S2, S3			
C3.2	Adapter une recette aux règles d'un établissement (sans alcool) et à des besoins individuels	S2, S3			
C3.2	Poser un cadre de confidentialité et de non-jugement dans un atelier	S2, S3			
C3.2	Appliquer l'hygiène et la sécurité (viande hachée, volaille, œufs, couteaux, transport)	S2, S3			
C3.3	Calculer un risque relatif et son intervalle de confiance ; discuter causalité et biais	S1, S3			
C3.3	Calculer un intervalle de confiance et une taille d'échantillon corrigée	S1, S3			
C3.4	Organiser une veille sur la protection des données, les compléments et l'influence commerciale	S1, S3			
C3.5	Concevoir une communication qui ne stigmatise pas ; gérer son identité numérique	S1, S3			
C3.6	Respecter le secret et le secret partagé, les données personnelles, le droit à l'image ; refuser un conflit d'intérêts	S1, S2, S3			

Modèles officiels utilisés : structure des sujets U62 (2002-2014) et E5.B (2021-2024) pour le bon de commande, la fiche technique et l'organisation ; sujet U62 « atelier cuisine en réadaptation cardiaque » pour l'atelier avec des patients hospitalisés ; BTS blanc CNED E5B pour l'adaptation d'une recette et le calcul nutritionnel ; texte de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024) pour la répartition des compétences entre les deux temps.

DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE

CHAPITRE 7

Démarche de projet (1) : diagnostic, priorités et objectifs

Mots-clés : Démarche de projet (1), Analyse de situation, Diagnostic, Priorités, Objectifs

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 7 · Démarche de projet (1) : diagnostic, priorités et objectifs · version normale

1

COURS

Mise en page normale · 94 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 97

2

FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 7 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 98 à 104

3

CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 117 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 105 à 221

4

ANNALES E5

Mise en page normale · 42 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 222 à 263

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 • Cours **4**

7.1 Compétences mobilisées 6
7.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6
7.3 Cours 8
7.4 Approfondissements 72
7.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 77
7.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 78
7.7 L'essentiel à retenir 83
7.8 Entraînement 84
7.9 Glossaire 95
7.10 Renvois bibliographiques par notion 96
7.12 Bibliographie numérotée 97

2 • Fiche de révision et fiches-outils **98**

Fiche de révision du chapitre 7 100
1. Le cycle de projet 100
2. Les définitions à savoir 100
3. Les formules 101
4. Le questionnaire en 8 étapes 101
5. Les pièges 101
6. Auto-test 101
7. Flashcards 101
Compléments du chapitre enrichi 102
Fiches-outils du chapitre 7 102
O7.1 – Grille d'analyse de situation 102
O7.2 – Guide d'entretien semi-directif (professionnel) 102
O7.3 – Grille de prétest d'un questionnaire 103
O7.4 – Grille de priorisation (Hanlon + PEARL) 103
O7.5 – Grille de vérification des objectifs SMART 103
O7.6 – Calculateur de précision (à la main) 103

3 • Cahier d'exercices **105**

Cahier d'exercices – Chapitre 7 108
Partie 1 – Le projet et l'analyse de situation 110
Partie 2 – Recueillir les données sur le terrain 126
Partie 3 – Analyser et présenter les données 142
Partie 4 – Échantillonnage et précision 155
Partie 5 – Poser le diagnostic 167
Partie 6 – Définir les priorités 181
Partie 7 – Problématique et objectifs 195
Partie 8 – Synthèse : diagnostic en situation réelle et cas complet 206
Bilan : grille d'auto-évaluation 221

4 • Annales E5 ..... **222**

Cahier d'annales E5 – chapitre 7 224
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 225
Partie II – Les corrigés détaillés 238
Grille d'auto-évaluation 262

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS

CHAPITRE

07

Démarche de projet (1) : diagnostic, priorités et objectifs

Démarche de projet (1) | Analyse de situation | Diagnostic | Priorités | Objectifs

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

7.1 Compétences mobilisées 6

7.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6

7.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 7

7.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 7

7.3 Cours 8

7.3.1 Qu'est-ce qu'un projet de santé publique ? 8

7.3.2 L'analyse de situation 14

7.3.3 Recueillir des données sur le terrain 21

7.3.4 Analyser et présenter les données 29

7.3.5 Poser le diagnostic 35

7.3.6 Définir les priorités 41

7.3.7 Rédiger les objectifs 45

7.3.8 Choisir un échantillon en pratique 50

7.3.9 Les méthodes participatives de diagnostic 54

7.3.10 Analyser l'environnement alimentaire d'un territoire 57

7.3.11 Croiser les données : tableaux à double entrée 61

7.3.12 Formuler une problématique de projet 63

7.3.13 Du diagnostic à la stratégie : la matrice FFOM croisée 66

7.3.14 Fil rouge : le diagnostic d'Inès pas à pas 68

7.3.15 Rédiger la partie « analyse de situation et diagnostic » d'un dossier 71

7.4 Approfondissements 72

7.4.1 Le diagnostic local de santé et le contrat local de santé 72

7.4.2 La participation des habitants au diagnostic 73

7.4.3 S'appuyer sur les données probantes 73

7.4.4 Le diagnostic en milieu scolaire, en entreprise et en établissement 74

7.4.5 Mesurer les inégalités dans le diagnostic 75

7.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 77

7.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 78

Méthodes pour l'épreuve E5 : réussir les questions de diagnostic 80

Méthode 4 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve 81

Méthode 5 – Relier le diagnostic aux autres chapitres 82

Méthode 6 – Défendre son diagnostic à l'oral 82

7.7 L'essentiel à retenir 83

7.8 Entraînement 84

7.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 84

7.8.2 Exercices 85

7.8.3 Questions de réflexion 89

7.8.4 Étude de cas 90

7.8.5 Mises en situation express 91

7.8.6 Exercices complémentaires 93

7.9 Glossaire 95

7.10 Renvois bibliographiques par notion 96

7.12 Bibliographie numérotée 97

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- définir un projet de santé publique et en décrire le cycle, en le reliant aux fiches-outils F1 à F14 ;
- conduire une analyse de situation : rechercher des données fiables (territoire, population, santé, alimentation, offre, politiques, ressources), les citer et les dater ;
- distinguer les types de besoins (normatif, ressenti, exprimé, comparatif) et croiser les points de vue des habitants et des professionnels ;
- construire et administrer un outil de recueil (questionnaire, entretien, groupe de parole, observation), choisir un échantillon et calculer la précision d'une estimation ;
- analyser les données : calculs de pourcentages, de moyennes, d'écarts, de rapports ; présentation en tableaux et graphiques ;
- formuler un problème central et construire un arbre à problèmes, une analyse FFOM ;
- hiérarchiser des problèmes avec des critères explicites (méthode de Hanlon) ;
- rédiger des objectifs général, spécifiques et opérationnels SMART, et construire un arbre à objectifs ;
- rédiger la partie « analyse de situation et diagnostic » d'un dossier de projet.

7.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.1	Cœur de la compétence : analyser une situation, poser un diagnostic, définir des priorités et des objectifs	Analyse et diagnostic de situation posé ; priorités et objectifs formulés et adaptés au contexte
C3.2	Les objectifs et le diagnostic orientent le choix des thématiques d'ateliers	Besoins, objectifs et spécificités du public identifiés
C3.3	Construire un questionnaire, choisir un échantillon, calculer une marge d'erreur, analyser des données	Contexte et problématique identifiés ; méthodes et outils de collecte pertinents ; traitement et analyse réalisés
C3.4	Rechercher et sélectionner des données fiables et datées (Insee, Géodes, ORS, INCA)	Sources fiables repérées ; informations collectées, analysées, organisées

7.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Démarche de projet	Décrire les étapes et leur logique	Cycle de projet ; lien avec le stage et l'épreuve E5
Analyse de situation	Rechercher, sélectionner, citer des données	Sources officielles datées ; données locales
Besoins	Distinguer les types de besoins ; croiser les regards	Taxonomie de Bradshaw
Outils de recueil	Construire un questionnaire, une grille d'entretien	Biais, échantillon, éthique (chapitre 6), littératie (chapitre 5)
Analyse et présentation des données	Calculer, représenter, interpréter	Outils statistiques simples (chapitre 2) ; précision

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Diagnostic	Formuler un problème central et ses causes	Arbre à problèmes ; FFOM
Priorités	Choisir avec des critères explicites	Méthode de priorisation
Objectifs	Rédiger des objectifs hiérarchisés et SMART	Distinction objectifs / actions / indicateurs

7.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : bloc 3, compétence C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 63 pour les notions de la démarche de projet, p. 108 pour les étapes du projet et le rôle des autres blocs). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 7.2.2.

Texte	Critère ou notion	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 63	Définition d'un projet ; distinction projet, action, atelier ; caractéristiques d'un projet en santé publique	7.3.1 (définitions, tableau des termes, encadré « Repères » du CNED)
Guide 2025, p. 63	Appel à projets ; parties prenantes	7.3.1 (encadré « Repères » du CNED) ; 7.3.2 (ressources et acteurs) ; chapitre 8
Guide 2025, p. 63	Étapes : analyse de la situation et diagnostic ; priorités et objectifs	7.3.2 à 7.3.7 ; 7.3.14 et 7.3.15 (fil rouge et rédaction)
Guide 2025, p. 63	Outils : questionnaire (de la rédaction au dépouillement), arbre à problèmes, arbre à objectifs, méthode SMART, mind-mapping, tableur, formulaire en ligne	7.3.3 et 7.3.4 (questionnaire, tableur) ; 7.3.5 (arbre à problèmes) ; 7.3.7 (arbre à objectifs, SMART)
Guide 2025, p. 108	Étapes de la démarche de projet et apports des autres blocs	7.3.1 (cycle de projet, figure 7.1)
Référentiel, C3.1	Analyse et diagnostic de situation posé ; priorités et objectifs formulés et adaptés au contexte	7.3.5 à 7.3.7 ; 7.3.13
Référentiel, C3.3 et C3.4	Méthodes et outils de collecte ; sources fiables, datées et organisées	7.3.3, 7.3.4, 7.3.8 ; 7.3.2 (citer une donnée)

7.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le fascicule du CNED *Environnement professionnel – Les essentiels* (2e année) traite la démarche de projet dans sa séquence 2 et les priorités de santé dans sa séquence 3. Le tableau relie chaque passage à ce cours.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Essentiels S2 §2 (p. 10 et 11)	Définition du projet selon l'Afnor ; parties prenantes (équipe, partenaires, usagers) ; étapes du diagnostic à l'évaluation (doc. 3)	7.3.1 (définition, encadré « Repères » du CNED, cycle de projet)
Essentiels S2 §2 (p. 12)	Communication, valorisation et capitalisation ; cadre à respecter (Code de la santé publique, déontologie, éthique, secret)	7.3.1 (encadré « Repères » du CNED) ; chapitres 6 et 9

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Essentiels S2 §3 (p. 12)	Démarche d'étude ; données « froides » et « chaudes » ; outils : remue-méninges, QQOQCP, Ishikawa, champ de forces, arbre des causes, carte mentale, AFOM	7.3.1 (encadré « Repères » du CNED) ; 7.3.2 à 7.3.5 ; 7.3.13 (FFOM) ; chapitre 13 (Ishikawa)
Essentiels S3 §1.2 et §2 (p. 14 à 16)	Priorité sanitaire, programme, planification ; Stratégie nationale de santé	7.3.1 (politique, programme, projet) ; 7.3.6 (cohérence avec les politiques)

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été corrigé

- **Stratégie nationale de santé** : le fascicule cite la SNS 2018-2022 (p. 16). Elle est terminée ; le projet de SNS 2023-2033 n'était pas encore adopté en mai 2026. Pour justifier une priorité, on cite le **PNNS 5 (2026-2030)**, lancé le 8 avril 2026, et la **SNANC 2025-2030**.
- **Sigles des instances** (p. 14 et 15) : la conférence régionale s'appelle la **CRSA** (conférence régionale de la santé et de l'autonomie), et non « CRAS » ; le **HCSP** est le Haut **Conseil** de la santé publique depuis 2004 ; il n'existe pas de « CNSP » : la Conférence nationale de santé (**CNS**) est l'instance de démocratie sanitaire.
- **Champ de forces** (p. 12) : il faut lire forces « **motrices** » (favorables) et non « matrices ».
- **AFOM et FFOM** : les deux sigles désignent le même outil (SWOT en anglais) ; ce cours emploie FFOM (forces, faiblesses, opportunités, menaces).
- **Études nationales** : INCA 3 (2014-2015) et Esteban (2014-2016) restent les dernières publiées. L'enquête **Albane** a lancé son premier cycle en juin 2025 (plus de 3 000 personnes) ; le recueil se termine fin 2026 et les premiers résultats sont attendus début 2028 (Santé publique France et ANSES, 10 juin 2025).
- **Annales du chapitre** : les documents citaient le PNNS 4 (2019-2023) ; ils citent maintenant le PNNS 5 (2026-2030).

7.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

7.3.1 Qu'est-ce qu'un projet de santé publique ?

Module · Guide 2025 : p. 63 ; p. 108 · CNED : Essentiels M1 S2 §2 (p. 10 et 11) ; Essentiels M1 S2 §2 (p. 12) ; Essentiels M1 S2 §3 (p. 12) ; Essentiels M1 S3 §1.2 et §2 (p. 14 à 16)

Définition – Projet

Ensemble **coordonné** d'actions, limité dans le **temps**, doté de **moyens** définis, conduit par une équipe pour atteindre des **objectifs** précis en réponse à un **problème** ou à un **besoin** identifié. En santé publique, le projet vise la santé d'une **population** (un groupe, un territoire) et non celle d'un individu.

Terme	Définition et exemple
Politique	Orientations et priorités fixées par une autorité (PNNS 5, Projet régional de santé)
Programme	Ensemble de projets et d'actions coordonnés répondant à une politique (programme régional nutrition)
Projet	Ensemble d'actions limitées dans le temps, pour des objectifs précis (« Bien manger, petit budget, grand plaisir »)
Action	Activité concrète du projet (un cycle de 6 ateliers culinaires)
Séance	Unité d'animation (l'atelier n° 3 du 28 mars)

Le cycle de projet

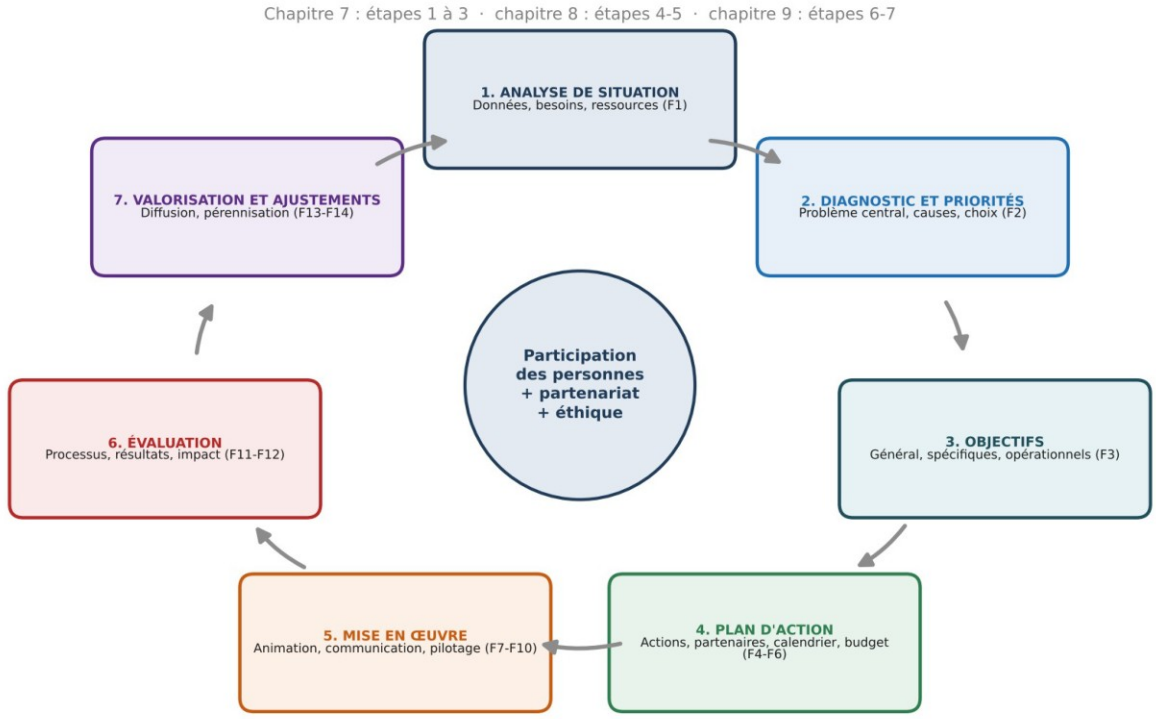


Figure 7.1 – Le cycle de projet en santé publique

Comprendre le schéma – Figure 7.1

1. Analyse de situation : rassembler les données sur le territoire, le public, les problèmes, les ressources et les politiques (fiche F1).

2. Diagnostic et priorités : formuler le problème central, ses causes et ses conséquences, puis choisir sur quoi agir (fiche F2).

3. Objectifs : traduire les causes choisies en objectifs hiérarchisés et mesurables (fiche F3).

4. Plan d'action : choisir les actions, les partenaires, le calendrier, le budget (fiches F4 à F6 ; chapitre 8).

5. Mise en œuvre : animer, communiquer, piloter (fiches F7 à F10 ; chapitre 8 et volume 2).

6. Évaluation : mesurer ce qui a été fait et ce qui a changé (fiches F11, F12 ; chapitre 9).

7. Valorisation et ajustements : diffuser, pérenniser, améliorer (fiches F13, F14 ; chapitre 9).

8. Au centre : la **participation** des personnes concernées, le **partenariat** et l'**éthique** traversent toutes les étapes. La démarche est **cyclique** : l'évaluation nourrit un nouveau diagnostic.

Attention – Les trois erreurs les plus fréquentes

1. Commencer par l'action (« On va faire des ateliers cuisine ») avant d'avoir analysé la situation : le projet risque de ne pas répondre aux besoins et sera difficile à justifier devant un jury ou un financeur.

2. Confondre objectif et action : « animer 6 ateliers » est un objectif **opérationnel** (ce que fait l'équipe), pas un objectif spécifique (ce qui change chez le public).

3. Oublier l'évaluation dès la conception : si les indicateurs et l'état initial ne sont pas prévus avant l'action, on ne pourra pas mesurer d'évolution.

Des méthodes de référence

Plusieurs cadres structurent la démarche. Il n'est pas nécessaire de tous les maîtriser, mais il faut connaître leur logique commune : **partir des besoins**, **expliciter le raisonnement** et **prévoir l'évaluation**.

Cadre	Principe
Planification sanitaire (Pineault et Daveluy, La planification de la santé, 1986, rééd. 1995)	Étapes : détermination des besoins, priorités, objectifs, actions, mise en œuvre, évaluation
Modèle PRECEDE-PROCEED (Green et Kreuter)	Raisonner « à rebours » : de la qualité de vie et des problèmes de santé vers les comportements, leurs facteurs, puis l'intervention
Cadre logique (matrice)	Tableau reliant objectifs, résultats, activités, indicateurs, sources de vérification et hypothèses ; très utilisé par les financeurs
Guide d'autoévaluation de la qualité des actions (INPES, 2009)	Grille de questions sur chaque étape pour améliorer la qualité d'une action de promotion de la santé
Outil de catégorisation des résultats (Promotion Santé Suisse, adapté en France)	Classer les résultats attendus selon qu'ils portent sur les offres, les capacités, les environnements, les compétences ou la santé

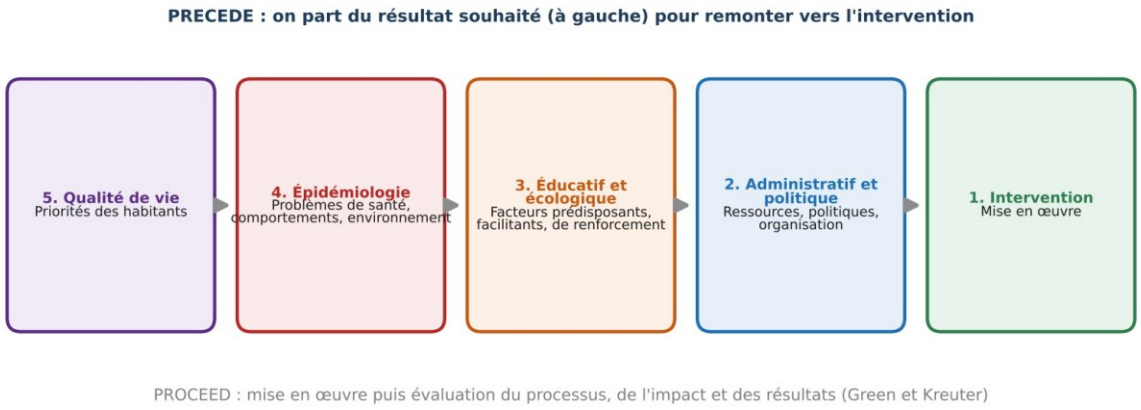


Figure 7.2 – La logique du modèle PRECEDE-PROCEED

Comprendre le schéma – Figure 7.2

1. On part de la **qualité de vie** souhaitée par la population (ce qui compte pour les habitants).
2. On identifie les **problèmes de santé** et les **comportements** et **environnements** qui y contribuent (épidémiologie).
3. On analyse les facteurs **prédisposants** (connaissances, attitudes, croyances), **facilitants** (compétences, accessibilité, prix, ressources) et de **renforcement** (soutien de l'entourage, valorisation).
4. On examine les conditions **administratives et politiques** (moyens, politiques, organisation).
5. On conçoit l'**intervention**, puis PROCEED décrit sa mise en œuvre et son évaluation (processus, impact, résultats).
6. Intérêt pour le diététicien : ce raisonnement évite de se limiter à l'information (facteur prédisposant) et oblige à agir sur les facteurs **facilitants** (savoir cuisiner, accès aux produits) et de **renforcement**.

Définition – Projet selon l'Afnor (repris par le CNED)

Un projet est un « processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant une date de début et une date de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conformément

à des exigences spécifiques, incluant des contraintes de délais, de coûts et de ressources ».

Repères – Projet, parties prenantes et outils de l'état des lieux (CNED)

- **Projet, action, atelier** : le projet est l'ensemble ; l'action est une activité du projet (un cycle d'ateliers) ; l'atelier est une séance collective d'animation, une des formes possibles de l'action.
- **Projet de santé publique** : il vise un groupe et non une personne seule ; il part d'un besoin de santé identifié ; il agit souvent sur les déterminants (environnement, compétences) et il est évalué.
- **Appel à projets** : un financeur (ARS, collectivité, Assurance maladie, fondation) publie un cahier des charges, un budget et une date limite ; l'équipe répond avec un dossier qui reprend le diagnostic, les objectifs, les actions, le budget et l'évaluation (chapitre 8).
- **Parties prenantes** : l'**équipe** du projet (elle met en commun ses compétences), les **partenaires** (appui humain, logistique, matériel ou financier, ponctuel ou régulier), les **usagers** ou bénéficiaires, et les **financeurs** et décideurs.
- **Démarche d'étude** : à ne pas confondre avec la démarche de projet ; elle analyse un thème, une population ou un territoire à partir de données **« froides »** (statistiques, rapports, bilans) et **« chaudes »** (questionnaires, entretiens, observations, réunions).
- **Outils de l'état des lieux** : remue-méninges (*brainstorming*) ; **QQOQCP** (qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi) ; diagramme d'**Ishikawa** ou causes-effet (chapitre 13) ; **champ de forces** (forces motrices favorables contre forces défavorables) ; arbre des causes ou à problèmes (7.3.5) ; carte mentale ; FFOM, aussi appelée AFOM ou SWOT (7.3.13).
- **Tout au long du projet** : on **communique** et on **valorise** les résultats auprès des partenaires et des financeurs ; on **capitalise**, c'est-à-dire qu'on garde des outils et des modèles pour de futurs projets. On respecte le Code de la santé publique, les recommandations, la déontologie, l'éthique et le secret professionnel (chapitre 6).

Qui fait quoi dans un projet ?

Un projet de santé publique réunit des personnes qui n'ont pas le même rôle. Les confondre crée des malentendus : un financeur n'est pas un pilote, un partenaire n'est pas un sous-traitant, et le public n'est pas un simple « bénéficiaire ». Le tableau suivant présente les rôles que l'on retrouve dans la plupart des projets, y compris dans un projet de stage.

Rôle	Définition	Exemple dans un projet « bien manger à petit budget »
Porteur du projet	Structure qui prend la responsabilité du projet, signe les demandes de financement et rend des comptes	Le centre social
Chef de projet (ou coordinateur)	Personne qui organise le travail, tient le calendrier et le budget, fait le lien entre tous	La conseillère en économie sociale et familiale, avec l'étudiant en diététique
Comité de pilotage	Instance qui **décide** : valide le diagnostic, les priorités, les objectifs, le budget, et suit l'avancement	Directeur du centre social, élue aux affaires sociales, représentant du financeur, deux habitantes
Comité technique (ou groupe de travail)	Instance qui **prépare** : construit les outils, analyse les données, propose des options	Étudiant, conseillère, animatrice de l'épicerie, infirmière de PMI
Partenaires opérationnels	Structures qui agissent dans le projet avec leurs moyens propres	Épicerie solidaire, PMI, école
Financeurs	Organismes qui apportent de l'argent et posent des conditions (objectifs, bilan)	ARS (appel à projets), commune, caisse d'allocations familiales

Rôle	Définition	Exemple dans un projet « bien manger à petit budget »
Public ou personnes concernées	Personnes dont la situation motive le projet ; elles participent aux décisions qui les concernent	Les familles du quartier
Personnes ressources	Personnes consultées pour leur expertise, sans engagement durable	Médecin scolaire, diététicienne de l'hôpital

La séparation entre **pilotage** et **technique** est importante. Le comité technique propose plusieurs options argumentées, le comité de pilotage choisit. Cette organisation évite qu'une seule personne décide de tout, et elle donne au projet une légitimité auprès des financeurs. Dans un petit projet de stage, les deux comités peuvent se réduire à quelques personnes, mais il faut toujours savoir **qui valide** chaque étape.

Lien diététique – La place du diététicien dans le projet

Le diététicien peut occuper plusieurs rôles : chef de projet dans un service de prévention, membre du comité technique dans une collectivité, personne ressource pour une association. Dans tous les cas, il apporte une expertise que les autres acteurs n'ont pas : traduire les repères nutritionnels en actions concrètes, adapter une recette à un budget et à un public, choisir des indicateurs alimentaires pertinents. Il doit aussi savoir ce qui ne relève pas de lui : la décision politique, le financement, le suivi social. Les parties prenantes et leur mobilisation sont développées au chapitre 8.

Exemple – La gouvernance d'un projet de stage

Clara, étudiante, effectue son stage de huit semaines dans un CCAS. Sa tutrice, conseillère en économie sociale et familiale, est cheffe de projet. Le comité de pilotage se réunit deux fois : en semaine 3 pour valider le diagnostic et les priorités, en semaine 8 pour valider les objectifs et le plan d'action. Il réunit la directrice du CCAS, l'adjointe aux solidarités, la responsable de l'épicerie solidaire et deux personnes accompagnées par le CCAS. Le comité technique, réuni chaque semaine pendant trente minutes, comprend Clara, sa tutrice et l'animatrice de l'épicerie. Clara rédige un relevé de décisions après chaque réunion du comité de pilotage : c'est la trace qu'elle pourra présenter au jury.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.1

Une mutuelle (fictive) veut lancer des ateliers « cuisine et diabète » dans trois communes. Classez les acteurs suivants dans les rôles du tableau : la mutuelle, qui finance et signe la convention ; la diététicienne salariée de la mutuelle, qui organise ; le réseau de santé diabète, qui prête une salle et une infirmière ; deux patients experts ; la conférence des financeurs ; un médecin généraliste consulté une fois. Indiquez ensuite qui doit valider le choix des communes.

Corrigé

La mutuelle est le **porteur** et un **financeur** ; la diététicienne est **cheffe de projet** ; le réseau diabète est **partenaire opérationnel** ; les patients experts représentent le **public** et peuvent siéger au comité de pilotage ; la conférence des financeurs est un **financeur** ; le médecin est une **personne ressource**. Le choix des communes revient au **comité de pilotage**, sur proposition argumentée du comité technique (données de diagnostic, faisabilité).

Organiser le diagnostic dans le temps : le rétroplanning

Un diagnostic prend du temps : il faut rencontrer les acteurs, construire et tester les outils, recueillir, analyser, restituer. En stage, le temps est court. On construit donc un **rétroplanning** : on part de la date à laquelle le

diagnostic doit être validé et l'on remonte le temps, étape par étape, en tenant compte des délais incompressibles (réunions à fixer, vacances scolaires, disponibilité des partenaires).

Semaine	Étape	Production attendue	Validation
1	Découverte de la structure, entretiens avec la tutrice et l'équipe ; recherche documentaire	Liste des sources et des personnes à rencontrer	Tutrice
2	Entretiens avec 4 à 6 professionnels ; construction du questionnaire ; demande de rendez-vous au comité de pilotage	Questionnaire et grille d'entretien	Tutrice
3	Prétest et correction ; début de la passation ; relevé de l'offre	Questionnaire définitif ; relevé de prix	Comité technique
4	Passation (plusieurs lieux, plusieurs horaires) ; groupe de parole avec le public	Données brutes	–
5	Saisie, calculs, analyse thématique ; arbre à problèmes	Tableaux, graphiques, arbre	Comité technique
6	Restitution au public et aux partenaires ; priorisation	Priorités argumentées	Comité de pilotage
7	Rédaction des objectifs et des premières pistes d'action	Objectifs SMART	Comité technique
8	Rédaction de la partie diagnostic du dossier ; présentation finale	Dossier et support oral	Comité de pilotage

Trois règles rendent le rétroplanning réaliste. D'abord, prévoir une **marge** d'environ 20 % du temps pour les imprévus : un partenaire qui annule, un questionnaire qui revient trop lentement. Ensuite, fixer les réunions de validation **dès la première semaine**, car les agendas des décideurs se remplissent vite. Enfin, distinguer les tâches qui peuvent se faire en parallèle (recherche documentaire et entretiens) de celles qui se suivent obligatoirement (prétest puis passation).

Astuce – Le diagramme de Gantt

Le rétroplanning se présente souvent sous la forme d'un **diagramme de Gantt** : les tâches en lignes, les semaines en colonnes, une barre colorée pour la durée de chaque tâche et un losange pour chaque validation (jalon). Un tableur suffit pour le construire. Il montre d'un coup d'œil les tâches qui se chevauchent et les dates à ne pas manquer. Le chapitre 8 l'utilise pour planifier les actions.

Exemple – Calcul d'une marge dans un planning

Yanis dispose de 8 semaines de 35 heures, soit 8 × 35 = **280 heures**. Les tâches de diagnostic sont estimées à 225 heures. La marge est de 280 − 225 = **55 heures**, soit 55 / 280 × 100 = **19,6 %** du temps : elle est proche des 20 % conseillés. Si la passation prend une semaine de plus que prévu (35 heures), il reste 55 − 35 = **20 heures** de marge, soit 20 / 280 × 100 = **7,1 %** : Yanis doit alors simplifier une étape (par exemple, réduire le nombre d'entretiens) pour ne pas compromettre la rédaction.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.2

Vous commencez un stage de 6 semaines le 4 mai dans une maison de quartier. Le comité de pilotage ne peut se réunir que les mardis. La passation du questionnaire doit éviter le pont de l'Ascension. Proposez un rétroplanning en six lignes (une par semaine) avec, pour chaque semaine, l'étape principale et la validation prévue. Indiquez ensuite deux tâches que l'on peut mener en parallèle.

Corrigé

Exemple : semaine 1, découverte, recherche documentaire, prise de rendez-vous pour deux comités de

pilotage (un mardi de la semaine 3 et un mardi de la semaine 6) ; semaine 2, entretiens avec les professionnels et construction du questionnaire, validé par la tutrice ; semaine 3, prétest, correction et début de la passation (en dehors du pont), point avec le comité de pilotage sur la méthode ; semaine 4, fin de la passation et groupe de parole ; semaine 5, analyse, arbre à problèmes, restitution au public et priorisation en comité technique ; semaine 6, objectifs, rédaction et présentation au comité de pilotage du mardi. Tâches en parallèle : la recherche documentaire et les entretiens avec les professionnels ; le relevé de l'offre alimentaire et la passation du questionnaire.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.1 – Le projet de santé publique

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez quatre caractéristiques d'un projet de santé publique.
2. Classez du plus large au plus précis : action, politique, séance, programme, projet.
3. Citez les sept étapes du cycle de projet.
4. Quelle est la différence entre le comité de pilotage et le comité technique ?
5. Dans le modèle PRECEDE-PROCEED, à quelle catégorie appartient « savoir cuisiner les légumes secs » ?
6. Pourquoi prévoir une marge d'environ 20 % dans un rétroplanning ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.1

1. Actions coordonnées, limitées dans le temps, moyens définis, objectifs précis, réponse à un problème identifié par un diagnostic, évaluation prévue (quatre suffisent).
2. Politique, programme, projet, action, séance.
3. Analyse de situation ; diagnostic et priorités ; objectifs ; plan d'action ; mise en œuvre ; évaluation ; valorisation et ajustements.
4. Le comité de pilotage décide et valide ; le comité technique prépare, analyse et propose.
5. Aux facteurs facilitants (compétences).
6. Pour absorber les imprévus (annulations, retards de passation) sans compromettre la rédaction et les validations.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 7.3.2.
3 ou 4 sur 6	Je relis le cycle de projet et le tableau des rôles.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 7.3.1 et je refais les exercices d'application.

7.3.2 L'analyse de situation

Module · Référentiel : C3.3, C3.4 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S2 §3 (p. 12)

Définition – Analyse de situation et diagnostic

L'**analyse de situation** (ou état des lieux) est la collecte et l'organisation des informations sur un territoire, une population, ses problèmes de santé, leurs déterminants, les ressources et les politiques existantes. Le **diagnostic** est l'**interprétation** de ces informations : il identifie et hiérarchise les problèmes et les besoins sur lesquels le projet va agir. On parle de **diagnostic partagé** lorsqu'il est construit avec les habitants et les partenaires.

Les besoins : croiser les regards

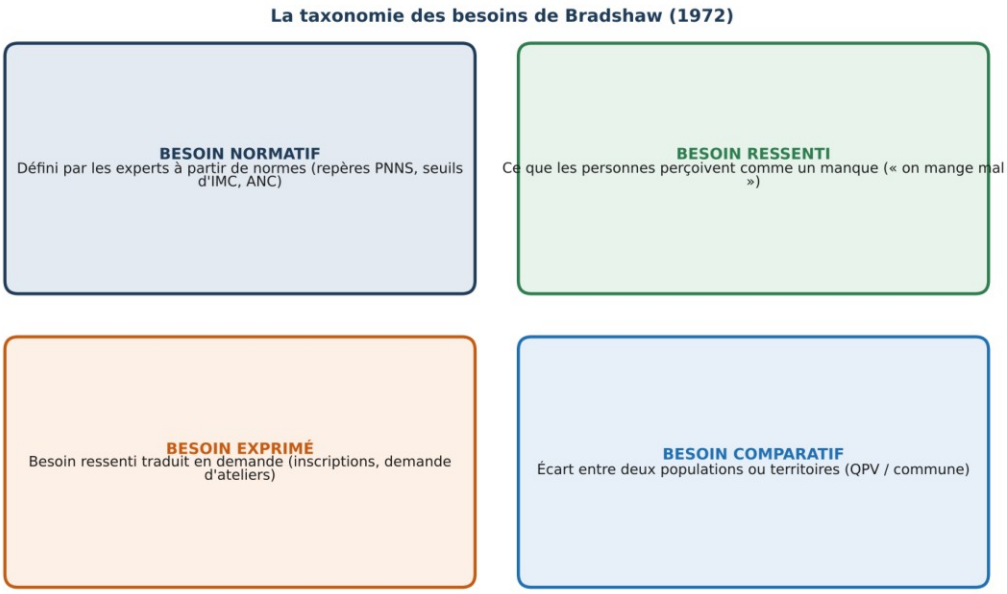


Figure 7.3 – Les quatre types de besoins (Bradshaw, 1972)

Comprendre le schéma – Figure 7.3

1. Besoin normatif : défini par les **experts** en comparant la situation à une norme (repères du PNNS, seuils de corpulence, recommandations de fréquence en restauration collective). Exemple : « 27 % seulement des familles consomment des légumes secs 2 fois par semaine, alors que le repère est d'au moins 2 fois. »

2. Besoin ressenti : ce que les personnes **perçoivent** comme un manque ou un problème (« Manger équilibré coûte cher »).

3. Besoin exprimé : besoin ressenti transformé en **demande** (26 parents sur 48 demandent des ateliers cuisine ; liste d'attente).

4. Besoin comparatif : écart entre la population étudiée et une population de **référence** (14 % d'enfants en surpoids dans les écoles du quartier contre 9 % dans le département).

5. Un besoin est d'autant plus **solide** qu'il est confirmé par plusieurs types : c'est la **triangulation**. Un besoin normatif non ressenti exige un travail de sensibilisation ; un besoin ressenti non normatif mérite d'être entendu (bien-être, convivialité).

Lien diététique – Besoins ressentis par les professionnels et besoins observés

Dans la pratique (et dans la fiche F1), on ajoute souvent les **besoins ressentis par les professionnels** (animatrice, infirmière scolaire, épicerie) et les **besoins observés** par l'étudiant lui-même (repérage de l'offre alimentaire, observation des goûters). Ils complètent la grille de Bradshaw et enrichissent le diagnostic.

Les rubriques d'une analyse de situation

Rubrique	Questions à se poser	Exemples de sources
Territoire	Où ? Taille, type (urbain, rural, QPV), accessibilité, transports	Insee, sig.ville.gouv.fr, Observatoire des territoires
Population	Qui ? Âge, composition des ménages, revenus, emploi, langues, scolarité	Insee (recensement, Filosofi), CAF, contrat de ville

Rubrique	Questions à se poser	Exemples de sources
État de santé	Quels problèmes ? Corpulence, maladies chroniques, santé bucco-dentaire, mortalité	Géodes (Santé publique France), ORS, Data pathologies (Assurance maladie), santé scolaire, PMI
Comportements alimentaires et activité physique	Que mangent-ils, comment ?	INCA 3, Esteban, Albane (national) ; enquête locale
Offre et environnement	Où acheter, à quel prix ? Restauration collective, offre de restauration rapide, espaces de jeux	Repérage terrain, relevé de prix, données commerciales
Ressources et acteurs	Qui agit déjà ? Structures, professionnels, associations, actions existantes	Entretiens, annuaires, comité local, portail des interventions probantes
Politiques et financements	Dans quel cadre ?	PNNS 5 / SNANC, PRS, CLS, PAT, contrat de ville, appels à projets
Besoins et attentes	Que veulent les personnes ?	Questionnaires, entretiens, groupes de parole

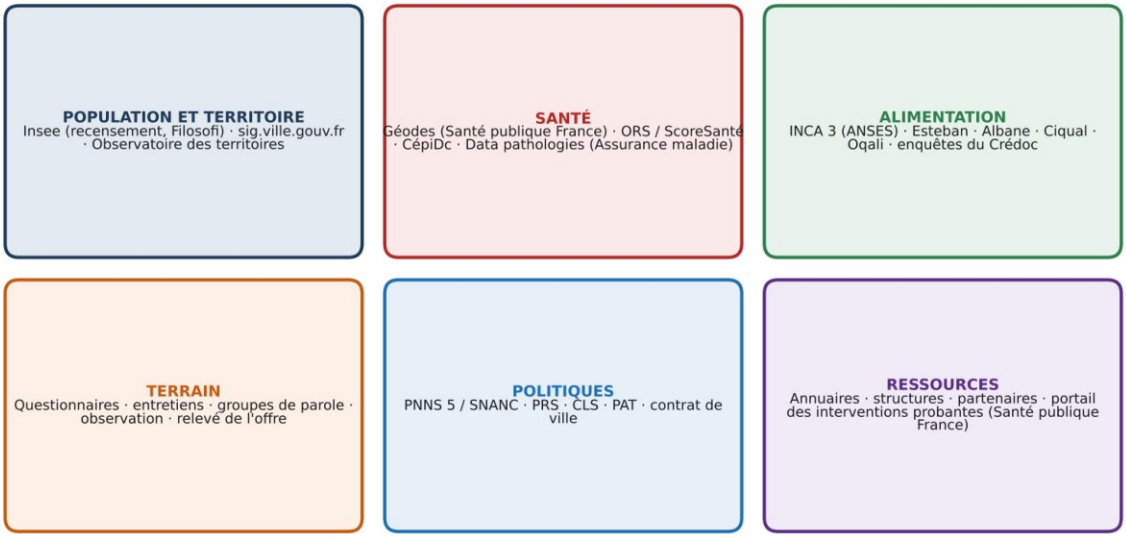


Figure 7.4 – Les principales sources de données d'un diagnostic

Méthode pas à pas – Citer correctement une donnée

Toute donnée du diagnostic est accompagnée de sa **source**, de son **année** (ou période de recueil) et, si nécessaire, de son **champ** (âge, territoire). Exemple : « Dans le département, 9 % des enfants de grande section sont en surpoids, obésité comprise (service de santé scolaire, bilans 2025-2026). » Un chiffre sans source ni date n'a pas de valeur devant un jury ou un financeur. Distinguez aussi les données **nationales** (contexte), **régionales**, **locales** (justification du projet) et **recueillies par vous** (enquête).

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Géodes** (*geodes.santepubliquefrance.fr*) : portail cartographique des indicateurs de santé de Santé publique France ; vérifier les dernières mises à jour départementales.
- **INCA 3** (ANSES, 2014-2015) et **Esteban** (Santé publique France, 2014-2016) restent les dernières grandes études nationales publiées sur les consommations et l'état nutritionnel.
- **Albane** : enquête nationale qui leur succède (consommations alimentaires, biomarqueurs, activité physique) ; son premier cycle a commencé en juin 2025 auprès de plus de 3 000 personnes, le recueil se

termine fin 2026 et les premiers résultats sont attendus début 2028 (Santé publique France et ANSES, 10 juin 2025).

- **Portail des interventions probantes ou prometteuses** de Santé publique France : à consulter avant de choisir une action.

Lire les indicateurs d'un territoire

L'analyse de situation utilise des indicateurs publiés par d'autres organismes. Les définitions de ces indicateurs (prévalence, incidence, taux standardisé) sont présentées au chapitre 2 et les grands producteurs de données au chapitre 17. Ici, l'objectif est pratique : savoir **choisir**, **lire** et **comparer** quelques indicateurs pour décrire un territoire en une page.

Indicateur	Ce qu'il mesure	Où le trouver	Piège à éviter
Structure par âge (part des moins de 20 ans, des 75 ans et plus)	Le poids des publics prioritaires	Insee, recensement de la population	Utiliser un recensement ancien sans donner l'année
Taux de pauvreté	Part des personnes dont le niveau de vie est inférieur à 60 % du niveau de vie médian national	Insee, Filosofi	Le confondre avec la part des allocataires d'un minimum social
Part des familles monoparentales	Un facteur de vulnérabilité économique et de manque de temps	Insee, recensement	Calculer sur les ménages au lieu des familles avec enfants
Habitants d'un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)	La concentration de difficultés sociales sur un territoire précis	Système d'information géographique de la politique de la ville, Insee	Généraliser aux habitants de toute la commune
Prévalence du surpoids des enfants	État de santé des enfants à un âge donné	Bilans de santé scolaire, PMI	Comparer des âges différents (grande section et 6e)
Personnes traitées pour un diabète	Poids d'une maladie chronique liée à l'alimentation	Assurance maladie (Data pathologies), Géodes	Comparer des territoires dont la structure par âge diffère sans taux standardisé
Équipements alimentaires	Commerces, marchés, restauration collective	Base permanente des équipements (Insee), repérage	Compter les commerces sans regarder ce qu'ils vendent

Définition – Prévalence et incidence (rappel)

La **prévalence** est la proportion de personnes atteintes à un moment donné : 380 personnes diabétiques dans une population de 5 000 habitants, soit 380 / 5 000 × 100 = **7,6 %**. L'**incidence** mesure les **nouveaux** cas pendant une période : 46 nouveaux diagnostics en un an dans la même population, soit 46 / 5 000 × 1 000 = **9,2 nouveaux cas pour 1 000 habitants par an**. Dans un diagnostic de projet, on utilise surtout des prévalences, parce que les incidences locales sont rarement disponibles.

Trois règles pour comparer un territoire

1. Toujours comparer à une référence. Un taux de pauvreté de 20,0 % (1 840 personnes pauvres sur 9 200) n'a de sens que comparé au département, à la région ou à la France, pour la même année et la même source.

2. Comparer ce qui est comparable. Une commune où vivent beaucoup de personnes âgées aura plus de personnes diabétiques, sans que l'alimentation y soit moins favorable. Pour comparer des territoires de structures d'âge différentes, on utilise des **taux standardisés**, que publient Géodes et les observatoires régionaux de la santé.

3. Se méfier des petits nombres. Sur un petit territoire, un indicateur repose sur peu de cas et varie beaucoup d'une année à l'autre. On cumule plusieurs années, on donne les effectifs, et l'on respecte le **secret statistique** : l'Insee ne diffuse pas certaines données pour de très petits effectifs, et l'étudiant ne doit pas publier une donnée qui permettrait de reconnaître une famille.

Attention – Une donnée nationale n'est pas une donnée locale

Il est utile de citer Esteban ou INCA 3 pour situer un problème, mais on écrit clairement « en France » et l'on donne l'année : « En France, 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient obèses (Esteban, Santé publique France, 2014-2016). » Présenter ce chiffre comme celui du quartier est une erreur de méthode que le jury relève toujours.

Lien diététique – Ce que l'on retient pour un projet de nutrition

Pour un projet d'alimentation, trois ou quatre indicateurs bien choisis suffisent souvent : la part du public visé (enfants, personnes âgées), un indicateur de revenus (taux de pauvreté), un indicateur de santé lié à l'alimentation (surpoids des enfants, diabète) et un indicateur d'offre (commerces de produits frais, distance au marché). Chacun est présenté avec sa source, son année et la comparaison à la référence. Les autres données vont en annexe.

Exemple – Calcul détaillé : décrire la commune des Ormeaux en quelques chiffres

La commune des Ormeaux (fictive) compte 7 350 habitants et 3 260 ménages (données fictives, recensement 2022). Le département sert de référence.

- Moins de 20 ans : 1 911 / 7 350 × 100 = **26,0 %**, contre 22,4 % dans le département ; rapport 26,0 / 22,4 = **1,16**.
- 75 ans et plus : 845 / 7 350 × 100 = **11,5 %**, contre 9,8 % ; rapport **1,17**.
- Ménages d'une seule personne : 1 290 / 3 260 × 100 = **39,6 %**, contre 37,1 % ; rapport **1,07**.

Lecture : la commune compte à la fois plus de jeunes et plus de personnes très âgées que le département, et un peu plus de personnes seules. Les deux extrêmes de l'âge sont surreprésentés : un projet d'alimentation pourra viser les familles, les personnes âgées ou les deux, ce que le diagnostic devra trancher.

Rédaction dans le dossier : « Aux Ormeaux, les moins de 20 ans représentent 26,0 % de la population et les 75 ans et plus 11,5 %, contre respectivement 22,4 % et 9,8 % dans le département (Insee, recensement 2022, données fictives pour l'exemple). »

Organiser l'analyse de situation : la grille en huit rubriques

Pour ne rien oublier, on remplit une grille avant de rédiger. Chaque case contient un ou deux faits sourcés, et l'on note les informations manquantes : elles orientent le recueil de terrain.

Rubrique	Ce que je sais (source, année)	Ce qui me manque	Comment l'obtenir
Territoire			
Population			
État de santé			
Comportements alimentaires et activité physique			
Offre et environnement			
Ressources et acteurs			
Politiques et financements			
Besoins et attentes			

La colonne « Ce qui me manque » est la plus utile : elle évite de construire un questionnaire trop long qui redemanderait ce que l'on sait déjà, et elle justifie chaque outil de recueil devant le jury.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.3

Dans la commune de Valdrôme (fictive, 4 820 habitants, 2 150 ménages), on compte 1 012 habitants de 60 à 74 ans, 627 habitants de 75 ans et plus et 946 ménages d'une seule personne. Dans le département, les 60-74 ans représentent 18,5 % de la population, les 75 ans et plus 10,4 % et les ménages d'une personne 38,0 %. Calculez les trois pourcentages de la commune et leur rapport au département, puis rédigez deux phrases de dossier.

Corrigé

60-74 ans : 1 012 / 4 820 × 100 = **21,0 %** ; rapport 21,0 / 18,5 = **1,14**. 75 ans et plus : 627 / 4 820 × 100 = **13,0 %** ; rapport 13,0 / 10,4 = **1,25**. Ménages d'une personne : 946 / 2 150 × 100 = **44,0 %** ; rapport 44,0 / 38,0 = **1,16**. Exemple de rédaction : « À Valdrôme, un habitant sur trois a 60 ans ou plus (34,0 %), et les 75 ans et plus y sont 1,25 fois plus représentés que dans le département. Près de la moitié des ménages (44,0 %) ne comptent qu'une personne, ce qui oriente le diagnostic vers l'isolement des personnes âgées au moment des repas (données fictives). »

Trouver des données locales : un parcours de recherche

Trouver les bonnes données prend du temps quand on ne sait pas où chercher. Le parcours suivant part du plus général au plus local. Les organismes producteurs et les grandes études nationales sont présentés au chapitre 17 ; ici, on retient l'ordre de recherche et ce que l'on note à chaque étape.

Étape	Où chercher	Ce que l'on y trouve	Ce que l'on note
1. Le territoire	Insee : dossier complet de la commune ou de l'intercommunalité	Population par âge, ménages, familles monoparentales, emploi, diplômes	Année du recensement ; champ (commune, quartier)
2. Les revenus	Insee : données Filosofi	Taux de pauvreté, niveau de vie médian	Année ; seuil utilisé (60 % du niveau de vie médian)
3. La santé	Géodes (Santé publique France), Data pathologies (Assurance maladie), ORS	Prévalences de pathologies, taux standardisés, recours aux soins	Indicateur exact ; standardisation ; période
4. Les politiques	Site de l'ARS (PRS), contrat local de santé, contrat de ville, projet alimentaire territorial	Priorités du territoire, actions existantes, financements	Date de signature ; fiche-action concernée
5. Les acteurs	Annuaires de la commune, centre social, CCAS, associations	Ressources existantes, partenaires possibles	Contact ; ce que fait déjà chaque acteur
6. Le terrain	Entretiens, observation, questionnaire	Ce qui manque dans les étapes 1 à 5	Méthode, dates, effectifs

Astuce – Le tableau des sources du dossier

Dès le premier jour, ouvrez un tableau à quatre colonnes : la donnée, la source exacte (organisme, titre, page ou lien), l'année de la donnée et la date de consultation. Ce tableau évite de chercher une seconde fois une source perdue, et il sert directement à rédiger la bibliographie du dossier.

Exemple – Une donnée bien citée, une donnée mal citée

Mal citée : « Le taux de pauvreté est élevé dans la commune (environ 25 %). » On ne sait ni la source, ni l'année, ni à quoi le comparer.

Bien citée : « En 2021, 24,8 % des habitants de la commune vivaient sous le seuil de pauvreté, contre 15,6 % dans le département (Insee, Filosofi 2021 ; chiffres fictifs pour l'exemple). » Le lecteur connaît la source, l'année, la référence et l'écart.

Attention – Les sites sans source

Un article de blog ou un site commercial qui cite « une étude » sans référence n'est pas une source pour un diagnostic. On remonte à la source d'origine (rapport, base de données officielle) ou l'on n'utilise pas le chiffre. La méthode de lecture critique des sources est détaillée au chapitre 19.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.4

Vous préparez le diagnostic d'un projet pour les personnes âgées vivant seules dans une commune de 12 000 habitants. Pour chacune des informations suivantes, indiquez où la chercher et ce que vous noterez : a) la part des 75 ans et plus vivant seuls ; b) le nombre de bénéficiaires du portage de repas ; c) les priorités de santé du territoire ; d) les difficultés des personnes pour faire leurs courses.

Corrigé

a) Insee, recensement de la population (ménages selon l'âge) : année du recensement, champ communal, comparaison au département. b) Le CCAS ou le service qui organise le portage : nombre de bénéficiaires, année, conditions d'accès ; donnée agrégée seulement. c) Le contrat local de santé ou le projet régional de santé de l'ARS : date, fiche-action sur la nutrition ou le vieillissement. d) Aucune base ne le dit : il faut un recueil de terrain (entretiens avec des personnes âgées et des aides à domicile, questionnaire court lors du portage), avec méthode, dates et effectifs.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.2 – L'analyse de situation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la différence entre l'analyse de situation et le diagnostic ?
2. Citez les quatre types de besoins de Bradshaw.
3. Citez les huit rubriques d'une analyse de situation.
4. Comment l'Insee définit-il le seuil de pauvreté ?
5. 46 nouveaux cas en un an pour 5 000 habitants : calculez l'incidence pour 1 000 habitants.
6. Quelles trois informations accompagnent toujours une donnée citée dans un dossier ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.2

1. L'analyse de situation rassemble et organise les informations ; le diagnostic les interprète (problèmes, besoins, causes, ressources).
2. Normatif, ressenti, exprimé, comparatif.
3. Territoire ; population ; état de santé ; comportements ; offre et environnement ; ressources et acteurs ; politiques et financements ; besoins et attentes.
4. Un niveau de vie inférieur à 60 % du niveau de vie médian.
5. 46 / 5 000 × 1 000 = 9,2 nouveaux cas pour 1 000 habitants par an.
6. La source, l'année (ou la période) et le champ (âge, territoire).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 7.3.3.

Mon score	Ce que je fais
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau des indicateurs et la grille en huit rubriques.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 7.3.2 et je refais l'exercice sur Valdrôme.

7.3.3 Recueillir des données sur le terrain

Module · Référentiel : C3.3, C3.4 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S2 §3 (p. 12)

Les données existantes (statistiques, études) donnent le **contexte** ; les données recueillies sur le terrain apportent la connaissance **fine** du public et de ses besoins. On combine généralement des méthodes **quantitatives** (combien ? quelle proportion ?) et **qualitatives** (pourquoi ? comment ? quel sens ?).

Méthode	Principe	Avantages	Limites
Questionnaire	Questions standardisées, majoritairement fermées, à un échantillon	Chiffres comparables ; nombreux répondants ; avant/après	Réponses déclaratives ; littératie (chapitre 5) ; taux de réponse
Entretien semi-directif	Conversation guidée par une grille de thèmes, avec un professionnel ou un habitant	Compréhension approfondie ; découverte de causes	Temps ; petit nombre ; subjectivité de l'analyse
Groupe de parole (focus group)	6 à 10 personnes échangent sur un thème avec un animateur	Dynamique de groupe ; représentations ; idées d'actions	Effet de groupe (conformisme) ; personnes qui ne parlent pas
Observation	Observation directe et structurée (grille) d'un repas, d'un goûter, d'un lieu	Comportements réels, non déclaratifs	Présence de l'observateur modifie les comportements ; temps
Relevé de l'offre	Repérage des commerces, relevé de prix, cartographie	Données objectives sur l'environnement	Instantané ; ne dit rien des usages
Analyse documentaire	Rapports d'activité, bilans, études locales, sites	Rapide ; données déjà validées	Données parfois anciennes ou non adaptées

Construire un questionnaire

Méthode pas à pas – Les 8 étapes d'un questionnaire

1. Définir l'objectif : quelles informations sont nécessaires pour le diagnostic (ou l'évaluation) ? Chaque question doit servir l'objectif.

2. Lister les variables : caractéristiques du répondant (tranche d'âge, nombre d'enfants), comportements (fréquence de consommation), connaissances, opinions, attentes.

3. Choisir le type de question : fermée à choix unique, à choix multiples, échelle (Likert de 1 à 5, smileys), numérique, ouverte courte.

4. Rédiger : mots simples, une seule idée par question, pas de négation, pas de question orientée (« Ne pensez- vous pas que… »), modalités exhaustives et exclusives (« Jamais / 1 fois par semaine / 2 à 3 fois / 4 fois ou plus »).

5. Ordonner : des questions simples et neutres vers les plus personnelles ; caractéristiques à la fin ; 10 minutes au maximum.

6. Ajouter la mention d'information RGPD (chapitre 6) et le caractère facultatif et anonyme.

7. Tester auprès de 3 à 5 personnes du public (prétest) : compréhension, durée, modalités manquantes ; corriger.

8. Prévoir l'analyse : grille de dépouillement ou tableur (fiche F11 ; calculateur, feuille 5) **avant** la passation.

Erreur	Exemple à éviter	Correction
Question double	« Mangez-vous des fruits et des légumes tous les jours ? »	Deux questions : fruits, puis légumes
Question orientée	« Pensez-vous comme nous que les sodas sont mauvais ? »	« Combien de fois par semaine vos enfants boivent-ils des sodas ? »
Modalités qui se chevauchent	« 1 à 2 fois / 2 à 4 fois »	« 1 à 2 fois / 3 à 4 fois »
Modalités non exhaustives	« Supermarché / marché »	Ajouter « épicerie solidaire / autre (préciser) »
Vocabulaire technique	« Consommez-vous des légumineuses ? »	« Mangez-vous des lentilles, pois chiches, haricots secs ? » (avec photos)
Période floue	« Mangez-vous souvent du poisson ? »	« Au cours de la semaine dernière, combien de fois… ? »

Les biais à connaître

Biais	Définition et exemple
Biais de sélection	L'échantillon ne ressemble pas à la population visée : interroger les parents à la sortie de l'école touche ceux qui y viennent (pas les parents qui travaillent tôt)
Biais de non-réponse	Ceux qui répondent diffèrent de ceux qui ne répondent pas (les familles les plus en difficulté répondent moins)
Biais de désirabilité sociale	On répond ce qui semble « bien » (surdéclaration des fruits et légumes, sous-déclaration des sodas)
Biais de mémoire	Difficulté à se souvenir précisément de consommations passées
Biais de l'enquêteur	La manière de poser la question influence la réponse (ton, reformulation)

Astuce – Réduire les biais sans moyens importants

Diversifier les lieux de passation (école, épicerie, PMI, marché) ; proposer une passation orale avec médiatrice ; garantir l'anonymat ; utiliser des périodes de référence courtes (« la semaine dernière ») ; former les enquêteurs à lire les questions mot pour mot ; décrire honnêtement les limites dans le dossier.

L'échantillon et la précision d'une estimation

Dans un projet de terrain, on interroge rarement toute la population : on étudie un **échantillon**. Un pourcentage observé sur un échantillon est une **estimation**, entourée d'une **marge d'erreur** qui dépend surtout de la **taille** de l'échantillon (et suppose un échantillon tiré au hasard, ce qui est rarement le cas sur le terrain : la marge réelle est souvent plus grande).

Méthode pas à pas – Marge d'erreur d'un pourcentage (intervalle de confiance à 95 %)

$e = 1{,}96 \times \sqrt{p \times (1 - p) / n}$, où p est la proportion observée (entre 0 et 1) et n la taille de l'échantillon. L'intervalle de confiance est **$[p - e ; p + e]$**. **Taille d'échantillon** nécessaire pour une marge e souhaitée : **$n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$** (avec p = 0,5 si l'on n'a aucune idée de la proportion, ce qui donne la taille maximale).

Exemple – Calcul détaillé : la précision de l'enquête d'Inès

71 % des 48 parents interrogés (34/48) pensent que « manger équilibré coûte cher ».

- p = 34 / 48 = **0,708** ; 1 − p = **0,292**.

- p × (1 − p) = 0,708 × 0,292 = **0,2067** ; divisé par n : 0,2067 / 48 = **0,004307**.
- Racine carrée : √0,004307 = **0,0656** ; × 1,96 = **0,129**, soit **± 12,9 points**.
- Intervalle de confiance à 95 % : 70,8 − 12,9 = **57,9 %** à 70,8 + 12,9 = **83,7 %**.

Interprétation : même avec la marge d'erreur, **plus de la moitié** des parents partagent cette représentation : le résultat est suffisamment solide pour orienter le projet. En revanche, on ne pourrait pas affirmer qu'un écart de 5 points entre deux groupes de 48 parents est significatif. **Taille d'échantillon** pour une marge de ± 5 points avec p inconnu : n = $1{,}96^2$ × 0,5 × 0,5 / $0{,}05^2$ = 3,8416 × 0,25 / 0,0025 = 0,9604 / 0,0025 = **384,2**, soit **385 personnes** (on arrondit toujours au supérieur). Pour ± 10 points : 0,9604 / 0,01 = 96,04, soit **97 personnes**.

Attention – Ne pas surinterpréter un petit échantillon

Avec 12 familles, un passage de 3 à 7 familles (25 % à 58 %) est encourageant mais très imprécis : on présente alors les **effectifs** (« 7 familles sur 12 ») plutôt que des pourcentages seuls, et on évite les décimales inutiles. Règle pratique : en dessous de 20 répondants, toujours donner les effectifs.

Mener un entretien de diagnostic

L'entretien semi-directif sert à comprendre **pourquoi** une situation existe. Il complète le questionnaire, qui dit **combien**. En stage, on interroge en général deux types de personnes : des **professionnels** (directrice de centre social, infirmière scolaire, cuisinier, travailleur social) et des **habitants** ou usagers. Les premiers décrivent l'organisation et les ressources ; les seconds disent leurs pratiques, leurs freins et leurs attentes.

La **grille d'entretien** liste quatre à six thèmes, avec pour chacun une question d'ouverture et quelques relances. On ne lit pas la grille comme un questionnaire : on laisse la personne parler, et l'on vérifie à la fin que tous les thèmes ont été abordés.

Thème	Question d'ouverture	Relances possibles
Les repas de la semaine	Pouvez-vous me raconter comment se passent les repas chez vous en semaine ?	Qui cuisine ? À quelle heure ? Où mange-t-on ?
Les courses	Où faites-vous vos courses, et comment choisissez-vous ce que vous achetez ?	Moyen de transport ; budget ; promotions
Les difficultés	Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous en ce moment pour les repas ?	Temps ; prix ; goûts des enfants ; matériel
Les ressources	Qui ou quoi vous aide déjà ?	Famille ; voisins ; associations ; sites de recettes
Les attentes	Si une action était proposée ici, qu'est-ce qui vous donnerait envie d'y venir ?	Horaire ; garde des enfants ; format

Méthode pas à pas – Conduire un entretien en cinq temps

1. Présenter : qui je suis, le but de l'entretien, sa durée (20 à 40 minutes), l'anonymat et le droit de ne pas répondre (chapitre 6 pour l'information et le consentement).

2. Ouvrir : une question large et facile, qui met la personne à l'aise.

3. Approfondir : relancer par la reformulation (« Si je comprends bien, le soir vous manquez de temps… ») plutôt que par des questions fermées.

4. Vérifier : parcourir la grille et aborder les thèmes oubliés.

5. Conclure : remercier, demander s'il y a autre chose à ajouter, expliquer comment les résultats seront restitués.

Astuce – Prendre des notes sans enregistrer

L'enregistrement facilite l'analyse mais il impose un accord écrit et il intimide certaines personnes. Une solution simple consiste à noter les mots-clés pendant l'entretien, puis à rédiger un compte rendu détaillé **dans l'heure qui suit**, en recopiant mot pour mot les phrases marquantes. Ces phrases deviendront les verbatims du dossier.

Animer un groupe de parole

Le groupe de parole (ou focus group) réunit six à dix personnes qui partagent une situation, autour d'un animateur et d'un observateur qui prend les notes. Il fait apparaître les **représentations** (« manger sain, c'est pour les riches »), les désaccords et des idées d'actions auxquelles l'équipe n'avait pas pensé. Il dure de 60 à 90 minutes.

Le **guide d'animation** prévoit une activité d'accroche (un photolangage, des emballages à classer), trois ou quatre questions ouvertes et un temps de synthèse. L'animateur veille à ce que chacun parle, reformule sans juger et ne donne pas son avis sur ce qui est dit : un groupe de diagnostic n'est pas un atelier d'éducation.

Attention – L'effet de groupe

Dans un groupe, les personnes ont tendance à se ranger à l'avis de la majorité ou de celle qui parle le plus fort. On réduit cet effet en faisant d'abord écrire chacun sur un papier (une idée par papier) avant la discussion, et en donnant explicitement la parole aux personnes silencieuses. Les techniques du groupe nominal et du photolangage (partie 7.3.9) reposent sur ce principe.

Analyser les entretiens : de la note au thème

L'analyse thématique a été présentée en partie 7.3.4. En pratique, on construit un tableau : une ligne par thème, une colonne par entretien, et l'on coche les thèmes évoqués. On compte ensuite le nombre de personnes qui citent chaque thème.

Exemple – Calcul détaillé : neuf entretiens avec des parents

Clémence a mené 9 entretiens avec des parents d'un quartier (données fictives). Elle a compté le nombre de parents qui évoquent chaque thème.

- Prix des produits frais : 7 parents sur 9, soit 7 / 9 × 100 = **77,8 %**.
- Manque de temps le soir : 6 / 9 × 100 = **66,7 %**.
- Goûts des enfants : 5 / 9 × 100 = **55,6 %**.
- Équipement de cuisine insuffisant : 3 / 9 × 100 = **33,3 %**.
- Isolement au moment des repas : 2 / 9 × 100 = **22,2 %**.

Rédaction : avec moins de 20 personnes, on donne les effectifs. « Le prix des produits frais est le frein cité par 7 parents sur 9 ; une mère explique : *“Les légumes, je les achète quand il y a une promotion, sinon c'est des pâtes.”* » Les pourcentages servent seulement à classer les thèmes.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.5

Un groupe de parole réunit 8 bénéficiaires d'une épicerie solidaire. Six personnes évoquent le coût des produits frais, cinq le transport jusqu'au marché et trois le manque d'idées de recettes. Classez les thèmes, calculez le pourcentage de chacun, puis rédigez une phrase de dossier correcte.

Corrigé

Coût : 6 / 8 × 100 = **75,0 %** ; transport : 5 / 8 × 100 = **62,5 %** ; recettes : 3 / 8 × 100 = **37,5 %**. Avec 8 personnes,

la phrase doit donner les effectifs : « Le coût des produits frais est le frein le plus souvent cité (6 participants sur 8), devant le transport jusqu'au marché (5 sur 8) ; le manque d'idées de recettes est évoqué par 3 participants. » Écrire « 75 % des bénéficiaires » serait abusif : le groupe ne représente pas tous les bénéficiaires de l'épicerie.

Mesurer ce que mange le public : quelle méthode pour un diagnostic ?

Un diagnostic de projet a souvent besoin d'une idée des consommations : les enfants mangent-ils les légumes servis ? Les familles achètent-elles des légumes secs ? Les grandes méthodes d'enquête alimentaire (rappel de 24 heures, enregistrement, questionnaire de fréquence) sont décrites au chapitre 4, et leur place dans une étude au chapitre 18. Ici, on retient seulement ce qui est réaliste pendant un stage de quelques semaines.

Méthode	Ce qu'elle apporte au diagnostic	Ce qu'elle demande	Réaliste en stage ?
Questionnaire de fréquence court (8 à 12 aliments)	La fréquence de consommation de quelques aliments repères	Une liste d'aliments adaptée au public et des modalités claires	Oui, c'est l'outil le plus courant
Rappel de 24 heures	Ce qui a été mangé la veille, avec les quantités	Un entretien de 20 à 30 minutes et un enquêteur formé	Oui, sur un petit nombre de personnes
Enregistrement sur 3 jours	Les consommations détaillées de plusieurs jours	Une forte motivation du participant	Rarement : beaucoup d'abandons
Pesée des restes en restauration collective	Ce qui est réellement consommé par un groupe	Une balance, l'accord de la cuisine, deux ou trois services	Oui, très utile en milieu scolaire
Observation des plateaux (échelle visuelle)	Une estimation rapide des restes par assiette	Une grille (rien, un quart, la moitié, trois quarts, tout)	Oui, avec deux observateurs
Relevé des achats ou des tickets de caisse	La structure du panier d'une famille	La confiance des familles	Parfois, en épicerie solidaire

Définition – Le taux de restes

Le **taux de restes** est la part de la quantité servie qui n'est pas consommée : **taux de restes = masse des restes / masse servie × 100**. On peut aussi l'exprimer **par convive** : masse des restes / nombre de convives. On le calcule composante par composante (entrée, plat protidique, légumes, produit laitier, dessert, pain), car une moyenne globale cache les écarts.

Exemple – Calcul détaillé : la pesée des restes d'un restaurant scolaire

Dans une école élémentaire (données fictives), 120 élèves déjeunent. La diététicienne stagiaire pèse ce qui est servi et ce qui revient en plonge pendant un service.

- Légumes (haricots verts) : servis 14,4 kg ; restes 5,9 kg ; taux 5,9 / 14,4 × 100 = **41,0 %**, soit 5,9 × 1 000 / 120 = **49,2 g** par élève.
- Plat protidique : servi 12,0 kg ; restes 1,5 kg ; taux **12,5 %**, soit **12,5 g** par élève.
- Pain : servi 6,0 kg ; restes 1,1 kg ; taux **18,3 %**, soit **9,2 g** par élève.
- Fruit : servi 18,0 kg ; restes 7,2 kg ; taux **40,0 %**, soit **60,0 g** par élève.
- Ensemble : restes 5,9 + 1,5 + 1,1 + 7,2 = **15,7 kg** pour 14,4 + 12,0 + 6,0 + 18,0 = **50,4 kg** servis, soit **31,2 %**.

Lecture : le taux global (31,2 %) masque deux composantes très peu consommées, les légumes et le fruit, qui portent les fibres et la vitamine C du repas. Un seul service ne suffit pas : on recommence sur au moins trois jours avec des menus différents avant de conclure.

Attention – Les limites des mesures de consommation

Toutes ces méthodes ont des limites. Les questionnaires et les rappels sont **déclaratifs** (biais de désirabilité sociale et de mémoire, partie 7.3.3). La pesée des restes mesure ce que le groupe laisse, pas ce que mange chaque enfant, et un enfant peut compenser au goûter. Dans le dossier, on présente la méthode, le nombre de jours ou de personnes, et l'on écrit « estimation ».

Lien diététique – Interpréter sans juger

Un taux de restes élevé n'est pas une « faute » des enfants. Il peut venir de la recette (légumes trop cuits, sans assaisonnement), de l'organisation (temps de repas trop court, bruit), du grammage (portion trop grande pour des enfants de 6 ans) ou de l'ordre de service. Le diagnostic cherche ces causes avec l'équipe de cuisine et les animateurs, ce qui prépare l'arbre à problèmes de la partie 7.3.5.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.6

Dans un collège, 280 repas sont servis. On a pesé : crudités servies 22,4 kg, restes 6,3 kg ; plat protidique servi 33,6 kg, restes 4,0 kg ; féculents servis 50,4 kg, restes 9,1 kg ; yaourt servi 35,0 kg, restes 2,1 kg (données fictives). Calculez le taux de restes de chaque composante et la masse de restes par élève pour les crudités. Quelle composante faut-il étudier en priorité ?

Corrigé

Crudités : 6,3 / 22,4 × 100 = **28,1 %** ; 6,3 × 1 000 / 280 = **22,5 g** par élève. Plat protidique : 4,0 / 33,6 × 100 = **11,9 %**. Féculents : 9,1 / 50,4 × 100 = **18,1 %**. Yaourt : 2,1 / 35,0 × 100 = **6,0 %**. Les crudités sont la composante la moins consommée : on recherche ses causes avec la cuisine et les élèves (recette, présentation, place sur le plateau) avant de proposer une action. On vérifie le résultat sur d'autres jours.

L'observation structurée : regarder avec une grille

L'observation donne accès aux **comportements réels**, sans passer par ce que les personnes déclarent. Pour qu'elle soit utilisable dans un diagnostic, elle doit être **structurée** : on observe des éléments définis à l'avance, notés de la même façon par tous les observateurs, pendant plusieurs séances.

Méthode pas à pas – Construire une grille d'observation

1. Choisir quatre à huit éléments observables, liés aux questions du diagnostic (ce qui est servi, ce qui est mangé, la durée du repas, le bruit, l'aide apportée).

2. Définir chaque élément et ses modalités sans ambiguïté : « légume consommé : rien, un quart, la moitié, trois quarts, tout ».

3. Tester la grille sur un repas, à deux observateurs, et comparer les notes.

4. Observer au moins trois séances, à des jours différents, en se plaçant discrètement.

5. Calculer les résultats et les présenter avec le nombre de séances et d'observations.

Exemple – Calcul détaillé : la consommation des légumes estimée au quart près

Dans un restaurant scolaire (fictif), une stagiaire observe 30 plateaux d'élèves de CE2 un jour où des haricots verts sont servis. Elle note la part de légumes consommée : tout, 6 plateaux ; trois quarts, 5 ; la moitié, 8 ; un quart, 7 ; rien, 4.

- Part moyenne consommée : (6 × 1 + 5 × 0,75 + 8 × 0,5 + 7 × 0,25 + 4 × 0) / 30 = (6 + 3,75 + 4 + 1,75 + 0) / 30 = 15,5 / 30 = **51,7 %**.
- Plateaux où un quart au plus a été mangé : (7 + 4) / 30 × 100 = **36,7 %**.

Lecture : en moyenne, la moitié des légumes servis est consommée, et plus d'un élève sur trois en mange un quart au plus. Ce résultat est cohérent avec la pesée des restes (partie 7.3.3) et il peut être recueilli plus vite, sans balance.

Définition – L'accord entre observateurs

Pour vérifier qu'une grille est assez précise, deux observateurs notent les mêmes plateaux sans se concerter. Le **pourcentage d'accord** est le nombre de plateaux notés de la même façon divisé par le nombre de plateaux observés, multiplié par 100. Exemple : 34 accords sur 40 plateaux, soit 34 / 40 × 100 = **85,0 %**. En dessous d'environ 80 %, on précise les définitions et l'on forme les observateurs avant de continuer (des indices plus élaborés, qui tiennent compte des accords dus au hasard, existent en épidémiologie).

Attention – L'effet de l'observateur

Les personnes observées modifient souvent leur comportement : les animateurs encouragent davantage les enfants à goûter, les enfants finissent leur assiette pour faire plaisir. On réduit cet effet en observant plusieurs séances (l'effet diminue avec l'habitude), en restant discret et en expliquant à l'équipe que l'on observe une organisation, pas des personnes.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.7

Deux stagiaires observent 25 assiettes dans un EHPAD avec la même grille ; elles notent la même chose pour 19 assiettes. a) Calculez le pourcentage d'accord. b) Que faites-vous avant de poursuivre l'observation ? c) Citez deux éléments que l'on pourrait ajouter à la grille pour comprendre pourquoi les résidents laissent leur plat.

Corrigé

a) 19 / 25 × 100 = **76,0 %**. b) L'accord est insuffisant : on compare les assiettes notées différemment, on précise les définitions (par exemple, à partir de quelle quantité restante on note « la moitié »), on refait un essai à deux, puis on poursuit. c) Exemples : la texture servie (normale, hachée, mixée), l'aide apportée (aucune, stimulation verbale, aide totale), la température du plat à l'arrivée, le temps écoulé entre le service et la première bouchée.

Rendre le questionnaire accessible à tous

Les personnes qui ont le plus de difficultés à lire, à parler français ou à remplir un formulaire sont souvent celles que le projet veut atteindre. Un questionnaire difficile produit donc un **biais de sélection** : il ne recueille que l'avis des personnes à l'aise avec l'écrit. Les principes de la littératie en santé (chapitre 5) s'appliquent directement à la construction de l'outil.

Méthode pas à pas – Six règles pour un questionnaire accessible

1. Des phrases courtes : une idée par phrase, des mots du quotidien, aucune abréviation.

2. Des images : photos d'aliments, pictogrammes pour les fréquences (un rond par jour de la semaine), visages pour les échelles d'opinion.

3. Peu de questions : douze questions au plus, une seule question ouverte.

4. Une mise en page aérée : police de 12 points au moins, cases larges, une seule colonne.

5. Plusieurs modes de passation : papier, en ligne, et surtout **oral**, avec un enquêteur qui lit les questions mot pour mot.

6. Une traduction si une partie du public parle peu le français, faite par une personne de la langue et vérifiée par une seconde traduction vers le français.

Exemple – Avant et après : réécrire une question

Avant : « À quelle fréquence consommez-vous des fruits frais (hors jus) au cours d'une semaine habituelle ? »

Après : « La semaine dernière, combien de jours avez-vous mangé un fruit (pomme, banane, orange…) ? » suivi de huit cases illustrées : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours.

La seconde version donne une période précise, des exemples concrets et une réponse numérique simple. Elle est plus longue à lire, mais beaucoup plus facile à comprendre.

Organiser la passation et suivre le taux de réponse

La **passation** est le moment où le questionnaire est rempli. On choisit plusieurs **lieux** et plusieurs **horaires** pour toucher des personnes différentes, et l'on suit le nombre de questionnaires reçus dans chaque lieu. Le **taux de réponse** d'un lieu est le nombre de questionnaires reçus divisé par le nombre de questionnaires distribués ou de personnes sollicitées.

Lieu de passation	Mode	Distribués ou sollicités	Reçus	Taux de réponse
École (cartable)	Papier, à remplir seul	150	52	34,7 %
PMI (salle d'attente)	Oral, avec la stagiaire	25	18	72,0 %
Épicerie solidaire	Oral, avec une bénévole	40	31	77,5 %
Ensemble		215	101	47,0 %

La passation orale donne de bien meilleurs taux de réponse que le questionnaire envoyé dans le cartable : elle touche aussi des parents qui n'auraient pas rempli un formulaire seuls. Elle demande en revanche plus de temps et elle peut augmenter le biais de l'enquêteur, d'où la règle de lire les questions mot pour mot.

Définition – La représentativité d'un échantillon

Un échantillon est **représentatif** quand sa structure ressemble à celle de la population visée sur les caractéristiques importantes (âge, sexe, situation familiale, lieu de vie). Pour le vérifier, on compare les pourcentages de l'échantillon à ceux de la population, par exemple avec le recensement de l'Insee.

Exemple – Calcul détaillé : vérifier la représentativité

Sur les 101 répondants, 18 ont 60 ans ou plus, soit 18 / 101 × 100 = **17,8 %**, alors que cette tranche d'âge représente 27,5 % des adultes du quartier (données fictives). Le rapport est 17,8 / 27,5 = **0,65** : les personnes âgées sont sous-représentées. À l'inverse, 44 répondants vivent dans une famille monoparentale, soit **43,6 %**, contre 31,0 % des ménages du quartier ; le rapport est **1,41**. Ces écarts s'expliquent par les lieux choisis (école, PMI). Dans le dossier, on les signale comme une **limite**, et l'on ajoute si possible un lieu fréquenté par les personnes âgées (club, portage de repas).

À vous de jouer – Exercice d'application 7.8

Une stagiaire a distribué 160 questionnaires par les écoles (38 reçus), sollicité 30 personnes au marché en passation orale (27 réponses) et 50 personnes au centre social (35 réponses). Calculez le taux de réponse de chaque lieu et le taux global. Que conseillez-vous pour une prochaine enquête ?

Corrigé

Écoles : 38 / 160 × 100 = **23,8 %** ; marché : 27 / 30 × 100 = **90,0 %** ; centre social : 35 / 50 × 100 = **70,0 %**. Global : (38 + 27 + 35) / (160 + 30 + 50) = 100 / 240 × 100 = **41,7 %**. Conseil : privilégier la passation orale dans des lieux fréquentés par le public, ou accompagner la distribution par les écoles d'un temps de remplissage sur place (réunion de parents, café des parents). On vérifie ensuite la représentativité des répondants.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.3 – Recueillir des données sur le terrain

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle méthode répond à la question « pourquoi ? » et laquelle répond à « combien ? » ?
2. Citez les cinq temps de la conduite d'un entretien.
3. Comment réduit-on l'effet de groupe dans un groupe de parole ?
4. On a servi 18,0 kg de fruits et pesé 7,2 kg de restes : calculez le taux de restes.
5. Réécrivez la question « Mangez-vous souvent du poisson ? » pour la rendre précise.
6. 52 questionnaires reçus sur 150 distribués : calculez le taux de réponse.
7. Comment vérifie-t-on qu'un échantillon est représentatif ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.3

1. Les méthodes qualitatives (entretien, groupe de parole) répondent à « pourquoi ? » ; le questionnaire répond à « combien ? ».
2. Présenter, ouvrir, approfondir, vérifier, conclure.
3. En faisant d'abord écrire chacun seul avant la discussion, et en donnant la parole aux personnes silencieuses.
4. 7,2 / 18,0 × 100 = 40,0 %.
5. « La semaine dernière, combien de fois avez-vous mangé du poisson ? » avec des modalités chiffrées (0, 1, 2, 3 fois ou plus).
6. 52 / 150 × 100 = 34,7 %.
7. On compare la structure de l'échantillon (âge, situation familiale…) à celle de la population, par exemple avec le recensement.

Mon score	Ce que je fais
7 ou 6 sur 7	Je passe à la partie 7.3.4.
4 ou 5 sur 7	Je relis les méthodes d'entretien et le calcul du taux de restes.
Moins de 4 sur 7	Je relis toute la partie 7.3.3 et je refais les exercices d'application.

7.3.4 Analyser et présenter les données

Module · Référentiel : C3.3, C3.4 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S2 §3 (p. 12)

Les calculs de base

Calcul	Formule	Exemple
Pourcentage	effectif / total × 100	22 / 48 × 100 = 45,8 % des enfants boivent une boisson sucrée chaque jour
Écart en points	p1 − p2	14 % − 9 % = 5 points de surpoids en plus dans le quartier
Rapport (risque relatif simple)	p1 / p2	14 / 9 = 1,56 : la prévalence est 1,56 fois plus élevée, soit + 56 %

Calcul	Formule	Exemple
Variation relative	(valeur finale − valeur initiale) / valeur initiale × 100	(60 − 25) / 25 × 100 = + 140 %
Moyenne	somme des valeurs / nombre de valeurs	Score de connaissances : (4 + 6 + 5 + 7 + 3) / 5 = 5,0 / 10
Médiane	valeur centrale des données classées	3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 → 5
Taux de réponse	questionnaires reçus / distribués × 100	48 / 120 × 100 = 40 %

Attention – Points et pourcentages : ne pas confondre

Passer de 25 % à 60 %, c'est une hausse de **35 points** de pourcentage, mais une hausse **relative** de **140 %**. Écrire « une hausse de 35 % » est une erreur fréquente à l'écrit comme à l'oral.

Choisir la bonne représentation

Objectif	Représentation adaptée
Comparer des catégories (sources d'information, freins)	Diagramme en barres horizontales, triées du plus grand au plus petit
Montrer la répartition d'un tout (100 %) en 2 à 5 parts	Diagramme en secteurs (ou barre empilée unique)
Comparer avant/après ou deux territoires	Barres groupées
Suivre une évolution dans le temps	Courbe
Présenter des chiffres précis	Tableau avec effectifs et pourcentages, total, source

Méthode pas à pas – Les mentions obligatoires d'un tableau ou d'un graphique

Un **titre** qui dit ce qui est représenté (quoi, qui, où, quand) ; l'**effectif total** (n = 48) ; les **unités** ; la **source** et la date ; une **légende** si plusieurs séries ; des axes commençant à zéro pour les barres. Sous le graphique, une phrase d'**interprétation** (« Près de 3 parents sur 4… »).

Analyser des données qualitatives

Pour les entretiens et groupes de parole, on réalise une **analyse thématique** : retranscrire (ou prendre des notes détaillées), repérer les **thèmes** récurrents (le coût, le temps, les goûts des enfants), compter combien de personnes les évoquent, sélectionner des **verbatims** (citations anonymes) représentatifs. Exemple : thème « temps » cité par 6 participants sur 8 : « Le soir, je n'ai pas le courage de cuisiner. »

Dépouiller un questionnaire : du papier au tableur

Le **dépouillement** transforme les questionnaires remplis en données que l'on peut compter. Il se prépare avant la passation (partie 7.3.3, étape 8) et il suit toujours le même ordre : numéroter, coder, saisir, contrôler, calculer.

Méthode pas à pas – Saisir des données sans erreur

1. Numéroter chaque questionnaire reçu (Q001, Q002…) : on pourra retrouver le papier en cas de doute.

2. Établir le dictionnaire des codes : pour chaque question, la liste des réponses possibles et leur code (1 = oui ; 2 = non ; 9 = pas de réponse).

3. Saisir dans un tableur : **une ligne par questionnaire**, **une colonne par question**. On ne met qu'une information par cellule.

4. Contrôler : relire 1 questionnaire sur 10 contre sa saisie ; rechercher les valeurs impossibles (8 jours dans la semaine, âge de 150 ans) avec un filtre.

5. Traiter les non-réponses : on les compte, on les signale, et l'on calcule les pourcentages sur les **répondants** à la question, en donnant ce nombre (n = 45 sur 48).

N°	Q1 Nombre d'enfants	Q2 Jours avec un fruit (0 à 7)	Q3 Légumes secs ≥ 2 fois par semaine (1 oui, 2 non)	Q4 Lieu d'achat principal (code)
Q001	2	3	2	1
Q002	1	7	1	3
Q003	3	0	2	1
Q004	2	9 (pas de réponse)	2	2

Définition – Variable qualitative et variable quantitative

Une variable **qualitative** classe les personnes dans des catégories (lieu d'achat, oui ou non, niveau d'accord). On la résume par des **effectifs** et des **pourcentages**. Une variable **quantitative** est un nombre que l'on peut additionner (jours, euros, score sur 10). On la résume par une **moyenne**, une **médiane** et une mesure de dispersion (partie suivante). Le chapitre 16 approfondit ces notions.

Construire un tableau de fréquences

Le tableau de fréquences donne, pour chaque valeur, son **effectif**, son **pourcentage** et, si la variable est ordonnée, son **pourcentage cumulé** (la part des personnes qui ont cette valeur **ou moins**).

Exemple – Calcul détaillé : nombre de jours avec un fruit la semaine dernière (n = 48)

Jours	Effectif	Pourcentage	Pourcentage cumulé
0	6	12,5 %	12,5 %
1	5	10,4 %	22,9 %
2	8	16,7 %	39,6 %
3	9	18,8 %	58,3 %
4	6	12,5 %	70,8 %
5	5	10,4 %	81,3 %
6	3	6,3 %	87,5 %
7	6	12,5 %	100,0 %
Total	48	100,0 %	

- Pourcentage de la ligne « 2 jours » : 8 / 48 × 100 = **16,7 %** ; cumulé : (6 + 5 + 8) / 48 × 100 = 19 / 48 × 100 = **39,6 %**.
- Moyenne : (0 × 6 + 1 × 5 + 2 × 8 + 3 × 9 + 4 × 6 + 5 × 5 + 6 × 3 + 7 × 6) / 48 = 157 / 48 = **3,3 jours**.
- Médiane : les 24e et 25e valeurs, une fois classées, valent 3 (le cumul dépasse 50 % à la ligne 3) : médiane **3 jours**.
- Au moins 5 jours sur 7 : 5 + 3 + 6 = 14 personnes, soit 14 / 48 × 100 = **29,2 %**.

Lecture : moins d'un tiers des parents ont mangé un fruit au moins 5 jours sur 7 la semaine dernière, et un sur huit (12,5 %) n'en a mangé aucun. La somme des pourcentages arrondis fait 100,1 % : on l'indique en note (« total différent de 100 % en raison des arrondis ») plutôt que de modifier un chiffre.

Attention – Les pourcentages sur les répondants

Si 3 parents n'ont pas répondu à une question, on calcule les pourcentages sur 45 et non sur 48, et on l'écrit

(« n = 45 répondants »). Mélanger les deux bases dans un même tableau est une erreur fréquente : les pourcentages ne s'additionnent plus et le lecteur ne sait pas sur quoi ils portent.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.9

Sur 40 lycéens interrogés, 36 ont répondu à la question « Combien de jours avez-vous pris un petit-déjeuner la semaine dernière ? » : 0 jour : 5 ; 1 à 2 jours : 7 ; 3 à 4 jours : 9 ; 5 à 6 jours : 6 ; 7 jours : 9. Construisez le tableau de fréquences avec les pourcentages cumulés, puis rédigez une phrase d'interprétation.

Corrigé

Base : **36 répondants** (4 non-réponses). 0 jour : 5 / 36 = **13,9 %** (cumulé 13,9 %) ; 1 à 2 jours : 7 / 36 = **19,4 %** (cumulé 12 / 36 = **33,3 %**) ; 3 à 4 jours : 9 / 36 = **25,0 %** (cumulé 21 / 36 = **58,3 %**) ; 5 à 6 jours : 6 / 36 = **16,7 %** (cumulé 27 / 36 = **75,0 %**) ; 7 jours : 9 / 36 = **25,0 %** (cumulé **100,0 %**). Interprétation : « Un lycéen répondant sur quatre (25,0 %) a pris un petit-déjeuner tous les jours de la semaine précédente, mais un sur trois (33,3 %) en a pris au plus deux fois (n = 36 répondants sur 40, données fictives). »

Décrire une variable chiffrée : moyenne, médiane et dispersion

Pour une variable quantitative (budget, score, nombre de jours), la moyenne seule peut tromper. Une seule valeur très élevée suffit à la tirer vers le haut. On donne donc aussi la **médiane** et une mesure de **dispersion**, qui dit si les valeurs sont proches les unes des autres ou très étalées.

Indicateur	Définition	Intérêt	Limite
Moyenne	Somme des valeurs divisée par leur nombre	Utilise toutes les valeurs ; permet des calculs	Sensible aux valeurs extrêmes
Médiane	Valeur qui partage les données classées en deux moitiés égales	Résiste aux valeurs extrêmes	Ne tient pas compte de l'écart entre les valeurs
Étendue	Valeur maximale moins valeur minimale	Très simple	Dépend de deux valeurs seulement
Quartiles Q1 et Q3	Valeurs sous lesquelles se trouvent 25 % et 75 % des données	Décrivent la moitié centrale du groupe	Peu utiles avec moins de 10 valeurs
Écart interquartile	Q3 − Q1	Dispersion de la moitié centrale, sans les extrêmes	Moins connu des lecteurs, à expliquer

Méthode pas à pas – Trouver la médiane et les quartiles à la main

1. Classer les valeurs de la plus petite à la plus grande.

2. Médiane : avec un nombre impair de valeurs, c'est la valeur du milieu ; avec un nombre pair, c'est la moyenne des deux valeurs du milieu.

3. Q1 est la médiane de la moitié basse des valeurs, **Q3** la médiane de la moitié haute (méthode simple, adaptée à un dossier ; les tableurs utilisent des méthodes un peu différentes, qui donnent des résultats proches).

4. Écart interquartile = Q3 − Q1.

Exemple – Calcul détaillé : le budget alimentaire de 12 familles

Au cours des entretiens, 12 familles ont indiqué leur budget alimentaire par personne et par semaine, en euros (données fictives) : 18 ; 22 ; 25 ; 26 ; 28 ; 30 ; 31 ; 33 ; 35 ; 38 ; 41 ; 64.

- Moyenne : 391 / 12 = **32,6 €**.

- Médiane : 12 valeurs, donc moyenne des 6e et 7e valeurs : (30 + 31) / 2 = **30,5 €**.
- Q1 : médiane de 18, 22, 25, 26, 28, 30, soit (25 + 26) / 2 = **25,5 €** ; Q3 : médiane de 31, 33, 35, 38, 41, 64, soit (35 + 38) / 2 = **36,5 €**.
- Écart interquartile : 36,5 − 25,5 = **11,0 €** ; étendue : 64 − 18 = **46 €**.
- Sans la famille à 64 € : moyenne 327 / 11 = **29,7 €**, médiane **30 €**.

Lecture : une seule famille fait passer la moyenne de 29,7 € à 32,6 €, alors que la médiane ne bouge presque pas (30 € ou 30,5 €). Dans le dossier, on écrit : « La moitié des familles consacrent moins de 30,5 € par personne et par semaine à l'alimentation ; la moitié centrale se situe entre 25,5 € et 36,5 € (n = 12, déclaratif). »

Lien diététique – Comparer un budget à un repère

Un budget n'a de sens que comparé à un repère daté et sourcé : le coût d'un panier alimentaire conforme aux repères nutritionnels, calculé par une étude publiée, ou le coût des menus du projet calculé avec les prix relevés pendant le diagnostic. Le calcul du coût d'une recette est présenté aux chapitres 10 et 12. On évite de citer un chiffre de mémoire : on donne la source et l'année.

Attention – Moyenne d'une variable qualitative : une erreur à éviter

On ne calcule pas de moyenne sur des codes : si 1 = supermarché, 2 = marché et 3 = épicerie solidaire, la « moyenne de 1,8 » ne veut rien dire. Pour une échelle d'accord (de 1 « pas du tout d'accord » à 5 « tout à fait d'accord »), on présente plutôt la répartition en pourcentages et la part des réponses 4 et 5.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.10

Dix participants ont obtenu les scores de connaissances suivants sur 10 au premier atelier : 3 ; 4 ; 4 ; 5 ; 5 ; 6 ; 6 ; 6 ; 7 ; 8. Calculez la moyenne, la médiane, Q1, Q3 et l'écart interquartile. Rédigez la phrase qui servira de valeur initiale pour l'objectif spécifique de connaissances.

Corrigé

Somme : 54 ; moyenne 54 / 10 = **5,4 / 10**. Médiane : (5 + 6) / 2 = **5,5**. Q1 : médiane de 3, 4, 4, 5, 5, soit **4** ; Q3 : médiane de 6, 6, 6, 7, 8, soit **6** ; écart interquartile 6 − 4 = **2**. Phrase : « Au premier atelier, le score moyen de connaissances était de 5,4 sur 10 (médiane 5,5 ; la moitié centrale des participants entre 4 et 6 ; n = 10). » Un objectif spécifique pourra fixer une cible, par exemple un score moyen d'au moins 7 sur 10 en fin de cycle.

Construire un graphique honnête

Un graphique doit faire voir un résultat d'un coup d'œil, sans le déformer. Les mentions obligatoires ont été présentées plus haut ; voici les erreurs qui trompent le lecteur, même sans le vouloir.

Erreur	Ce qu'elle produit	Correction
Axe des barres qui ne commence pas à 0	Un écart de 4 points paraît énorme	Faire partir l'axe de 0 pour un diagramme en barres
Secteurs avec plus de 6 parts	Parts impossibles à comparer	Barres horizontales triées, ou regrouper en « autres »
Secteurs pour des réponses multiples	Le total dépasse 100 %, le cercle n'a plus de sens	Barres horizontales, avec la mention « plusieurs réponses possibles »
Effet 3D	Les parts au premier plan paraissent plus grandes	Graphique plat

Erreur	Ce qu'elle produit	Correction
Pourcentages sans effectif	Le lecteur ignore que n = 12	Ajouter n dans le titre ou sous le graphique
Couleurs sans signification	Le lecteur cherche un sens qui n'existe pas	Une seule couleur, ou une couleur pour mettre en valeur la donnée clé

Exemple – Calcul détaillé : l'effet d'un axe tronqué

Deux groupes : 52 % et 56 % de parents satisfaits. Sur un axe qui va de 0 à 100 %, la seconde barre est 56 / 52 = **1,08** fois plus haute que la première : l'écart paraît modeste, ce qui est juste. Sur un axe qui commence à 50 %, les hauteurs visibles sont 52 − 50 = 2 et 56 − 50 = 6 : la seconde barre paraît **3 fois** plus haute (6 / 2 = 3). Le même écart de 4 points donne une impression complètement différente. Pour un diagramme en barres, l'axe part toujours de 0.

Méthode pas à pas – Écrire la phrase d'interprétation

Sous chaque graphique, une phrase dit ce que le lecteur doit retenir. Elle contient : le **résultat principal** (le plus grand ou le plus petit, ou l'écart), le **chiffre** avec l'effectif, et si possible une **comparaison**. Exemple : « Le coût est le frein le plus cité (31 parents sur 48, soit 64,6 %), devant le manque de temps (22 sur 48, 45,8 %). » On évite de répéter toutes les valeurs du graphique.

Lien diététique – Un graphique pour chaque public

Pour le jury ou le comité de pilotage, un graphique précis avec effectifs et source. Pour une restitution aux habitants, un graphique très simple : trois barres au plus, des pictogrammes, une phrase en gros caractères. Les principes de la communication visuelle et de la littératie (chapitres 5 et 15) s'appliquent.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.11

Une stagiaire présente les freins cités par 48 parents (plusieurs réponses possibles) dans un diagramme en secteurs en 3D : coût 31, manque de temps 22, refus des enfants 19, manque d'idées 12, matériel 6. a) Calculez les pourcentages et leur somme. b) Expliquez pourquoi le diagramme choisi est inadapté et proposez un autre graphique. c) Rédigez la phrase d'interprétation.

Corrigé

a) Coût 31 / 48 = **64,6 %** ; temps 22 / 48 = **45,8 %** ; refus 19 / 48 = **39,6 %** ; idées 12 / 48 = **25,0 %** ; matériel 6 / 48 = **12,5 %** ; somme **187,5 %**. b) Avec des réponses multiples, le total dépasse 100 % : un diagramme en secteurs n'a pas de sens, et la 3D déforme les parts. On choisit des barres horizontales triées du plus grand au plus petit, avec l'axe de 0 à 100 %, la mention « plusieurs réponses possibles » et n = 48. c) « Le coût est le frein le plus souvent cité (31 parents sur 48, soit 64,6 %), devant le manque de temps (45,8 %) et le refus des enfants (39,6 %). »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.4 – Analyser et présenter les données

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans un tableur, que représentent une ligne et une colonne ?
2. Trois parents sur 48 n'ont pas répondu à une question : sur quel effectif calculez-vous les pourcentages ?
3. Donnez un exemple de variable qualitative et un exemple de variable quantitative.
4. Valeurs : 12 ; 15 ; 17 ; 20 ; 41. Calculez la moyenne et la médiane.
5. Pourquoi la médiane est-elle parfois préférable à la moyenne ?

6. Passer de 25 % à 60 % : combien de points et quelle variation relative ?
7. Citez quatre mentions obligatoires d'un graphique.

Corrigé – Point d'étape 7.3.4

1. Une ligne correspond à un questionnaire (une personne) ; une colonne correspond à une question (une variable).
2. Sur les 45 répondants, en l'indiquant (n = 45).
3. Qualitative : lieu d'achat, oui ou non. Quantitative : nombre de jours, budget en euros, score.
4. Moyenne : 105 / 5 = 21,0 ; médiane : 17.
5. Parce qu'elle n'est pas tirée par une ou deux valeurs extrêmes.
6. 35 points ; variation relative de + 140 %.
7. Titre, effectif total, unités, source et date, légende, phrase d'interprétation (quatre suffisent).

Mon score	Ce que je fais
7 ou 6 sur 7	Je passe à la partie 7.3.5.
4 ou 5 sur 7	Je refais le tableau de fréquences et le calcul des quartiles.
Moins de 4 sur 7	Je relis toute la partie 7.3.4 et je refais les exercices d'application.

7.3.5 Poser le diagnostic

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S2 §3 (p. 12)

Formuler le problème central

Le **problème central** est une situation **négative**, **observable** et si possible **mesurable**, qui concerne la santé d'un **public** sur un **territoire**. Il n'est ni une absence de solution (« manque d'ateliers cuisine » est une solution déguisée), ni un problème trop vaste (« l'obésité en France »).

Formulation à éviter	Formulation correcte
« Il n'y a pas d'ateliers cuisine au centre social »	« L'alimentation des familles du quartier des Tilleuls est peu diversifiée (peu de légumes et de légumes secs, boissons sucrées fréquentes chez les enfants) »
« Les jeunes mangent mal »	« Un tiers des lycéens de l'internat sautent le petit-déjeuner au moins 3 fois par semaine »
« Il faut lutter contre la dénutrition »	« Une part importante des résidents de l'EHPAD présente une perte de poids non expliquée au cours des 6 derniers mois »

L'arbre à problèmes

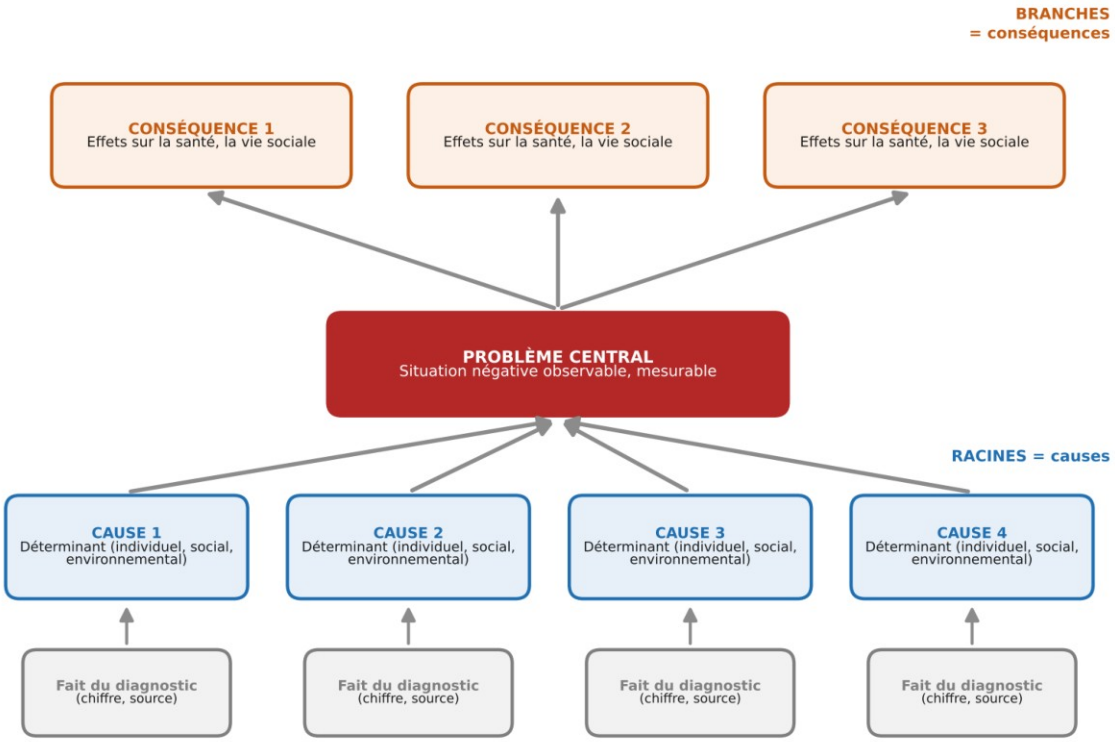


Figure 7.5 – La structure d'un arbre à problèmes

Comprendre le schéma – Figure 7.5

1. Le **tronc** est le problème central.
2. Les **racines** sont les **causes**, organisées en niveaux (causes directes, puis causes de ces causes) ; on peut les classer selon les déterminants du chapitre 2 (individuels, sociaux, environnementaux) ou selon PRECEDE (prédisposants, facilitants, de renforcement).
3. Chaque cause est appuyée par un **fait** du diagnostic (chiffre, verbatim, observation) avec sa source : c'est ce qui distingue un arbre argumenté d'un arbre « imaginé ».
4. Les **branches** sont les **conséquences** sur la santé (carences, surpoids, caries), la qualité de vie et la société.
5. Les flèches traduisent une relation **de cause à effet** (« parce que »). On lit l'arbre de bas en haut : « Parce que le budget est contraint… l'alimentation est peu diversifiée… ce qui entraîne… ».
6. L'arbre sert ensuite à choisir les causes sur lesquelles le projet **peut** agir (champ de compétence, moyens, partenaires) et à construire l'arbre à objectifs.

Méthode pas à pas – Construire l'arbre en groupe

Écrire chaque cause sur un papillon adhésif, les classer au tableau avec les partenaires ou les habitants, chercher les « causes des causes » en demandant « pourquoi ? » plusieurs fois, vérifier chaque lien (« est-ce vraiment une cause ? »), puis rattacher un fait à chaque cause. Une cause sans fait devient une **hypothèse** à vérifier.

L'analyse FFOM (SWOT) de la structure

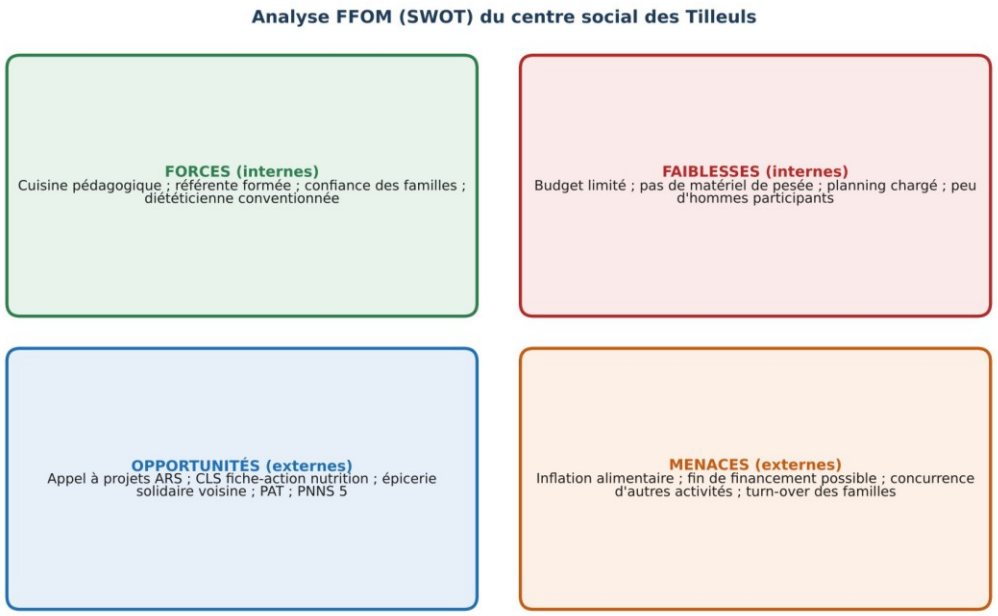


Figure 7.6 – Analyse FFOM du centre social des Tilleuls

Comprendre le schéma – Figure 7.6

1. Les **forces** et les **faiblesses** sont **internes** à la structure porteuse (moyens, compétences, locaux, image).
2. Les **opportunités** et les **menaces** sont **externes** (politiques, financements, partenaires, contexte économique).
3. L'analyse FFOM ne remplace pas le diagnostic de la population : elle évalue la **capacité** de la structure à porter le projet.
4. Elle oriente la stratégie : s'appuyer sur les forces pour saisir les opportunités (cuisine pédagogique + appel à projets ARS) ; corriger les faiblesses (acheter une balance grâce au budget) ; anticiper les menaces (diversifier les financements, prévoir la pérennisation).

Classer les causes pour ne rien oublier

Quand on construit l'arbre à problèmes, on risque de ne voir que les causes **individuelles** (« les parents ne savent pas cuisiner ») et d'oublier celles qui tiennent à l'environnement ou à l'organisation. Deux grilles aident à vérifier que toutes les familles de causes ont été explorées. La première reprend les **déterminants de santé** de Dahlgren et Whitehead (chapitre 2). La seconde reprend les trois catégories de **PRECEDE** (partie 7.3.1).

Famille de causes (PRECEDE)	Ce qu'elle regroupe	Exemple de cause	Fait qui l'appuie (source)
Facteurs prédisposants	Connaissances, croyances, attitudes, valeurs	« Manger équilibré coûte cher »	34 parents sur 48 le pensent (questionnaire)
Facteurs facilitants	Compétences, accès, prix, temps, équipement	Peu de compétences pour cuisiner les légumes secs	5 parents sur 8 le disent (groupe de parole)
Facteurs de renforcement	Réactions de l'entourage, normes, avantages perçus	Les enfants refusent les légumes, les parents renoncent	6 parents sur 8 (groupe de parole)
Environnement	Offre commerciale, prix, transports, politiques	Pas de primeur à moins de 800 m	Repérage, indice 28,6 sur 100

Méthode pas à pas – Vérifier un arbre à problèmes en quatre questions

1. Chaque cause est-elle une situation, et non une solution manquante ? « Pas d'ateliers » devient « peu de compétences culinaires ».

2. Chaque lien est-il un vrai « parce que » ? On lit la flèche à voix haute : « Les familles mangent peu de légumes secs **parce qu'elles** ne savent pas les cuisiner. »

3. Chaque cause repose-t-elle sur un fait ? Sinon, on l'écrit en pointillés comme **hypothèse** et l'on prévoit comment la vérifier.

4. Les quatre familles de causes sont-elles représentées ? Une famille vide signale soit une absence réelle, soit un oubli du recueil.

Exemple – Une cause, ses causes et ses faits

Dans un foyer de jeunes travailleurs (fictif), le problème central est « Les résidents prennent peu de repas complets en semaine ». Le stagiaire demande « pourquoi ? » trois fois de suite.

- **Pourquoi ?** Parce que beaucoup de résidents mangent des plats tout prêts ou sautent le repas du soir (questionnaire : 27 sur 45, soit 60,0 %).
- **Pourquoi ?** Parce qu'ils rentrent tard et que la cuisine collective est fermée après 21 h (règlement intérieur ; entretien avec le directeur).
- **Pourquoi ?** Parce que l'horaire a été fixé pour limiter le bruit, sans consulter les résidents (compte rendu du conseil de la vie sociale de 2024).

Lecture : la cause profonde est **organisationnelle** (horaire de la cuisine). Une action d'éducation seule n'y répondrait pas ; une proposition au conseil de la vie sociale (ouverture jusqu'à 22 h 30, règles de bruit) est une piste plus efficace.

Attention – Ne pas culpabiliser le public

Un arbre qui ne contient que des causes du type « les gens ne savent pas » ou « les gens ne font pas d'efforts » oublie les conditions de vie (revenus, horaires de travail, logement) et risque de stigmatiser le public. Les principes éthiques du chapitre 6 et l'approche par les déterminants du chapitre 2 rappellent que les comportements dépendent largement de l'environnement.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.12

Dans un EHPAD, le problème central est « Les résidents consomment moins de la moitié de leur plat principal le soir ». Voici des causes relevées : a) le dîner est servi à 18 h 00 ; b) certains résidents ont des difficultés de mastication ; c) les résidents pensent qu'à leur âge on a besoin de moins manger ; d) le personnel est réduit le soir et l'aide au repas manque ; e) les plats du soir sont souvent les mêmes. Classez chaque cause dans une famille (prédisposant, facilitant, renforcement, environnement ou organisation) et proposez un fait qui pourrait l'appuyer.

Corrigé

a) **Organisation** (environnement de l'établissement) : horaire relevé dans le planning, observation du repas. b) **Facilitant** (capacité physique) : bilan bucco-dentaire, nombre de résidents en texture modifiée. c) **Prédisposant** (croyance) : entretiens avec des résidents, verbatims. d) **Organisation** : effectifs du soir dans le planning, observation du nombre de résidents aidés. e) **Environnement** (offre) : analyse des menus sur quatre semaines, nombre de répétitions. Les deux causes organisationnelles relèvent de la direction ; elles seront discutées en comité de pilotage, car le projet nutritionnel seul ne peut pas les modifier.

Restituer le diagnostic

La **restitution** consiste à présenter les résultats du diagnostic aux personnes qui y ont participé et aux partenaires. Elle a trois fonctions. Elle **remercie** et **informe** les personnes qui ont donné de leur temps. Elle **valide** les résultats : le public et les professionnels confirment, nuancent ou corrigent l'interprétation. Elle **prépare la décision** : c'est souvent à ce moment que l'on priorise (partie 7.3.6).

Destinataire	Format adapté	Contenu à privilégier	Durée
Habitants ou usagers	Affiche, café-débat, temps convivial	3 à 5 résultats clés en phrases simples, illustrés ; ce qui va se passer ensuite	30 à 45 minutes
Équipe de la structure	Réunion d'équipe avec diaporama court	Résultats, causes, pistes d'action, rôle de chacun	30 minutes
Comité de pilotage	Note de synthèse de 2 pages et présentation	Problème central, priorités argumentées, objectifs proposés, moyens	45 à 60 minutes
Financeur	Partie diagnostic du dossier de demande	Données sourcées, besoins, cohérence avec la politique financée	Selon le dossier

Méthode pas à pas – Préparer une restitution aux habitants

1. Choisir trois à cinq résultats, ceux qui concernent directement le public.

2. Traduire chaque résultat en une phrase courte et une image : « 7 parents sur 9 trouvent les légumes trop chers » avec un pictogramme de panier.

3. Citer des verbatims anonymes, pour que chacun reconnaisse sa parole.

4. Poser une question à chaque résultat : « Est-ce que cela vous parle ? Qu'est-ce qui manque ? »

5. Noter les réactions : elles complètent le diagnostic et elles s'ajoutent au compte rendu.

6. Annoncer la suite : date de la décision, première action, façon de participer.

Astuce – La note de synthèse d'une page

Pour le comité de pilotage, une page suffit souvent : un titre, le problème central en une phrase, trois chiffres clés sourcés, l'arbre à problèmes simplifié, le tableau de priorisation et deux ou trois objectifs proposés. Les détails vont en annexe. Les décideurs lisent d'abord cette page : elle doit pouvoir être comprise sans le reste du dossier.

Exemple – Une restitution qui modifie le diagnostic

Lors de la restitution dans une résidence autonomie (fictive), la stagiaire présente le résultat « 15 résidents sur 40 disent ne plus avoir envie de cuisiner pour une seule personne ». Une résidente ajoute : « Ce n'est pas l'envie, c'est que les portions vendues sont trop grandes et qu'on jette. » Quatre autres résidents approuvent. La stagiaire ajoute une cause au diagnostic, « portions commerciales inadaptées aux personnes seules », appuyée désormais par 5 témoignages. Le plan d'action pourra intégrer des achats groupés et un atelier « cuisiner une portion et congeler le reste ».

Lien diététique – L'éthique de la restitution

On ne présente jamais un résultat qui permettrait de reconnaître une personne (« la seule famille de quatre enfants du bâtiment B ») et l'on ne restitue pas des données de santé individuelles. On évite aussi les formulations qui jugent (« les familles mangent mal »). Ces règles reprennent les principes du chapitre 6 sur la confidentialité et le respect des personnes.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.13

Vous avez réalisé un diagnostic auprès de 60 étudiants d'une résidence universitaire. Résultats : 38 sautent le petit-déjeuner au moins 3 fois par semaine ; 41 disent manquer d'argent en fin de mois ; 22 ne savent pas que l'épicerie solidaire du campus existe. Rédigez trois phrases de restitution destinées aux étudiants, avec les pourcentages arrondis à l'unité, et une question à leur poser pour chaque résultat.

Corrigé

38 / 60 = **63 %** ; 41 / 60 = **68 %** ; 22 / 60 = **37 %.** Exemples : « Près de deux étudiants sur trois (63 %) sautent le petit-déjeuner au moins 3 fois par semaine. Qu'est-ce qui vous en empêche le matin ? » ; « Plus de deux étudiants sur trois (68 %) disent manquer d'argent en fin de mois. Quelles solutions utilisez-vous déjà ? » ; « Plus d'un étudiant sur trois (37 %) ne connaît pas l'épicerie solidaire du campus. Comment aimeriez-vous en être informés ? » Les phrases sont simples, ne jugent pas et invitent à compléter le diagnostic.

La synthèse des besoins : un tableau de triangulation

Avant de rédiger le diagnostic, on rassemble tous les résultats dans un **tableau de triangulation**. Chaque ligne correspond à un besoin possible ; chaque colonne à un type de source. Un besoin confirmé par plusieurs sources est solide ; un besoin qui n'apparaît que dans une source reste une hypothèse.

Besoin possible	Données existantes (besoin normatif ou comparatif)	Professionnels	Public (besoin ressenti ou exprimé)	Observation	Solidité
Consommer plus de légumes secs	27 % des familles atteignent le repère (questionnaire)	L'épicerie note que les lentilles restent en rayon	« Je ne sais pas les faire » (5 parents sur 8)	Pas de légumes secs dans les colis préparés	Forte : 4 sources
Réduire les boissons sucrées au goûter	46 % des enfants en boivent chaque jour	L'infirmière scolaire le signale	Peu évoqué par les parents	Bouteilles de soda dans les sacs (sortie d'école)	Moyenne : besoin normatif, peu ressenti
Rompre l'isolement au moment des repas	Pas de donnée	Évoqué par l'animatrice familles	« Ce serait bien de cuisiner à plusieurs » (5 sur 8)	Pas d'observation	À confirmer

Méthode pas à pas – Lire le tableau de triangulation

1. Compter les sources qui confirment chaque besoin.

2. Repérer les décalages : un besoin normatif fort mais peu ressenti (les boissons sucrées) demandera un travail de sensibilisation avant une action de changement ; un besoin ressenti sans donnée objective (l'isolement) mérite un recueil complémentaire.

3. Écrire la solidité de chaque besoin en une phrase, avec les sources.

4. Transmettre les besoins solides à la priorisation (partie 7.3.6) et les hypothèses au plan de recueil.

Exemple – Rédiger une phrase de synthèse

« Le besoin d'augmenter la consommation de légumes secs est confirmé par quatre sources : il est normatif (seulement 27 % des familles atteignent le repère du PNNS), exprimé par les parents (5 sur 8 disent ne pas savoir les cuisiner), relevé par l'épicerie solidaire et visible dans la composition des colis. À l'inverse, le besoin de réduire les boissons sucrées est surtout normatif : peu de parents l'évoquent, ce qui oriente vers une approche de sensibilisation. »

À vous de jouer – Exercice d'application 7.14

Dans une résidence pour jeunes travailleurs, vous disposez des résultats suivants : 60 % des résidents déclarent sauter le repas du soir au moins deux fois par semaine (questionnaire, n = 45) ; le directeur signale que la cuisine collective ferme à 21 h ; 12 résidents demandent par écrit une ouverture plus tardive ; aucun résident n'évoque un manque de connaissances en nutrition ; l'infirmière du service de santé au travail a repéré plusieurs jeunes fatigués en fin de journée. Construisez une ligne du tableau de triangulation pour le besoin « prendre un repas du soir régulier », et indiquez sa solidité.

Corrigé

Données : 60 % des 45 répondants sautent le repas du soir au moins deux fois par semaine (besoin normatif par rapport au repère de trois repas par jour). Professionnels : le directeur (fermeture à 21 h) et l'infirmière (fatigue en fin de journée). Public : besoin exprimé par 12 demandes écrites d'ouverture plus tardive. Observation : à compléter (horaires de retour des résidents, fréquentation de la cuisine). Solidité : **forte** (trois types de sources concordants). La cause organisationnelle (horaires) ressort nettement, alors que les connaissances ne sont pas en cause.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.5 – Poser le diagnostic

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez trois caractéristiques d'un problème central bien formulé.
2. Pourquoi « manque d'ateliers cuisine » n'est-il pas un bon problème central ?
3. Dans quelle famille de PRECEDE classez-vous « les enfants refusent les légumes et les parents renoncent » ?
4. Que fait-on d'une cause qui ne repose sur aucun fait ?
5. Dans l'analyse FFOM, quels éléments sont internes à la structure ?
6. Citez les trois fonctions d'une restitution.

Corrigé – Point d'étape 7.3.5

1. Une situation négative, observable, si possible mesurable, qui concerne un public sur un territoire.
2. Parce que c'est une solution déguisée : il décrit ce qui manque au projet, pas la situation du public.
3. Facteurs de renforcement.
4. On la note comme une hypothèse (en pointillés) et l'on prévoit comment la vérifier.
5. Les forces et les faiblesses.
6. Remercier et informer les participants, valider les résultats, préparer la décision.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 7.3.6.
3 ou 4 sur 6	Je relis la vérification de l'arbre en quatre questions.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 7.3.5 et je refais l'exercice sur l'EHPAD.

7.3.6 Définir les priorités

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S3 §1.2 et §2 (p. 14 à 16)

Un diagnostic fait apparaître **plusieurs** problèmes ; aucun projet ne peut tout traiter. Choisir est un acte **argumenté** : le jury et les financeurs attendent des **critères explicites**.

Critère	Question
Ampleur	Combien de personnes sont concernées ?
Gravité	Quelles conséquences pour la santé et la qualité de vie ? Urgence ?
Efficacité de l'intervention	Existe-t-il des actions efficaces (portail des interventions probantes, littérature) ?
Faisabilité	La structure a-t-elle les moyens, les compétences, le temps ?
Acceptabilité	Le public et les partenaires sont-ils demandeurs ? (besoin exprimé)
Cohérence politique	Le problème est-il une priorité du PNNS, du PRS, du CLS ? (financements possibles)
Équité	Le projet réduit-il les inégalités ?

La méthode de Hanlon

Méthode pas à pas – Score de priorité de Hanlon

Chaque problème reçoit trois notes : **A = ampleur** (0 à 10), **B = gravité** (0 à 10), **C = efficacité** des interventions possibles (0 à 10). Le **score de priorité de base** est : **Score = (A + 2B) × C / 3** (la gravité compte double ; le score maximal est (10 + 20) × 10 / 3 = 100). On applique ensuite le **test PEARL** : **P**ertinence (relève-t-il de la mission de la structure ?), **É**conomie (coût raisonnable ?), **A**cceptabilité, **R**essources disponibles, **L**égalité. Chaque critère vaut 1 (oui) ou 0 (non) ; un seul 0 **écarte** le problème, quel que soit son score.

Exemple – Calcul détaillé : les priorités du centre social des Tilleuls

Inès et le comité de pilotage notent quatre problèmes issus du diagnostic.

Problème	A	B	C	Calcul (A + 2B) × C / 3	PEARL
P1 – Faible consommation de légumes et légumes secs	7	6	7	(7 + 12) × 7 / 3 = 133 / 3 = 44,3	1-1-1-1-1
P2 – Boissons sucrées quotidiennes chez les enfants	5	7	6	(5 + 14) × 6 / 3 = 114 / 3 = 38,0	1-1-1-1-1
P3 – Allaitement maternel court	3	6	4	(3 + 12) × 4 / 3 = 60 / 3 = 20,0	R = 0 (relève de la PMI)
P4 – Sédentarité des enfants	6	5	3	(6 + 10) × 3 / 3 = 48 / 3 = 16,0	1-1-1-0-1

Détail du calcul de P1 : 2B = 2 × 6 = 12 ; A + 2B = 7 + 12 = 19 ; 19 × 7 = 133 ; 133 / 3 = 44,33. **Classement** : P1 (44,3) > P2 (38,0) ; P3 et P4 sont écartés par le test PEARL (ressources : la PMI porte déjà une action sur l'allaitement, et le centre social n'a ni salle ni animateur sportif disponible). **Décision** : le projet traite P1 en priorité et intègre P2 dans un atelier « goûters et boissons » ; P3 donne lieu à une **orientation** des familles vers la PMI ; P4 est transmis au CLS (plaidoyer). **Limite** : les notes sont **subjectives** ; leur intérêt est de rendre le raisonnement **transparent** et discutable. On les attribue en groupe et on les justifie par les faits du diagnostic (A : 73 % des familles ne mangent pas de légumes secs 2 fois par semaine ; C : actions culinaires recensées comme prometteuses).

La grille multicritère pondérée

La méthode de Hanlon utilise trois critères seulement. Quand le comité de pilotage veut tenir compte d'autres critères (faisabilité, acceptabilité, équité), on construit une **grille multicritère pondérée**. Chaque problème reçoit une note de 1 à 5 pour chaque critère ; chaque critère a un **poids** qui traduit son importance ; le score est la somme des notes multipliées par les poids.

Méthode pas à pas – Construire une grille pondérée

1. Choisir quatre à six critères parmi ceux du tableau des critères (ampleur, gravité, efficacité, faisabilité, acceptabilité, cohérence politique, équité).

2. Fixer les poids avant de noter, en groupe : par exemple 3 pour les critères essentiels, 1 pour les critères secondaires.

3. Noter chaque problème de 1 (très défavorable) à 5 (très favorable), en justifiant chaque note par un fait du diagnostic.

4. Calculer : score = somme (note × poids). Le score maximal est 5 × somme des poids.

5. Exprimer le score en pourcentage du maximum pour le présenter simplement, puis classer.

Exemple – Calcul détaillé : trois problèmes dans un lycée professionnel

Le comité d'éducation à la santé d'un lycée (fictif) retient cinq critères : ampleur (poids 3), gravité (3), faisabilité (2), acceptabilité par les élèves (1), équité (1). Somme des poids : 10 ; score maximal : 5 × 10 = **50**.

Problème	Ampleur ×3	Gravité ×3	Faisabilité ×2	Acceptabilité ×1	Équité ×1	Score	% du maximum
Petit-déjeuner sauté	4	3	4	4	3	36	72,0 %
Boissons énergisantes	3	4	3	2	2	31	62,0 %
Repas du soir peu équilibré (internat)	4	4	2	3	4	35	70,0 %

- Petit-déjeuner : 4 × 3 + 3 × 3 + 4 × 2 + 4 × 1 + 3 × 1 = 12 + 9 + 8 + 4 + 3 = **36**, soit 36 / 50 × 100 = **72,0 %**.
- Repas du soir : 4 × 3 + 4 × 3 + 2 × 2 + 3 × 1 + 4 × 1 = 12 + 12 + 4 + 3 + 4 = **35**, soit **70,0 %**.
- Boissons énergisantes : 9 + 12 + 6 + 2 + 2 = **31**, soit **62,0 %**.

Lecture : les deux premiers problèmes sont très proches (36 et 35). Le repas du soir est plus grave et touche des élèves plus vulnérables (équité), mais il est moins faisable, car il dépend du prestataire de restauration. Le comité peut traiter le petit-déjeuner en priorité et ouvrir une discussion avec le prestataire pour le repas du soir.

Attention – Le poids des poids

Changer les poids change le classement. Si l'on donnait un poids de 3 à l'équité, le repas du soir passerait devant. C'est pourquoi les poids sont fixés **avant** de noter, en groupe, et écrits dans le compte rendu. Un classement obtenu en ajustant les poids après coup pour favoriser un problème n'est pas honnête.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.15

Trois problèmes A, B et C sont notés de 1 à 5 sur quatre critères : ampleur (poids 2), gravité (poids 3), faisabilité (poids 2), acceptabilité (poids 1). Notes : A = 5, 2, 4, 3 ; B = 3, 5, 2, 4 ; C = 4, 3, 5, 2. Calculez le score de chaque problème et son pourcentage du maximum. Que proposez-vous en cas d'égalité ?

Corrigé

Somme des poids : 8 ; maximum : 40. A : 5 × 2 + 2 × 3 + 4 × 2 + 3 × 1 = 10 + 6 + 8 + 3 = **27** (**67,5 %**). B : 6 + 15 + 4 + 4 = **29** (**72,5 %**). C : 8 + 9 + 10 + 2 = **29** (**72,5 %**). B et C sont à égalité. On peut départager par le critère de plus fort poids, la gravité (B = 5, C = 3), ce qui place B en tête ; ou bien discuter en groupe et vérifier les faits qui justifient les notes. On écrit dans le compte rendu la règle utilisée pour départager.

Noter à plusieurs : réduire la part de subjectivité

Les notes de Hanlon sont subjectives. Pour qu'elles reflètent un avis collectif, chaque membre du groupe note d'abord **seul**, puis on calcule la **moyenne** des notes de chaque critère avant d'appliquer la formule. Quand les notes d'un critère sont très dispersées (par exemple 2 et 9 pour le même problème), on en discute : la dispersion révèle souvent une information que tout le monde ne possède pas.

Exemple – Calcul détaillé : quatre membres notent trois problèmes

Dans une maison de santé pluriprofessionnelle (fictive), la diététicienne, l'infirmière, le médecin et la coordinatrice notent trois problèmes repérés chez les patients diabétiques de type 2.

Problème	Notes A	Moyenne A	Notes B	Moyenne B	Notes C	Moyenne C
P1 – Grignotage sucré le soir	6, 7, 5, 6	6,0	8, 7, 8, 9	8,0	6, 5, 6, 7	6,0
P2 – Repas sautés le midi au travail	8, 7, 8, 9	8,0	4, 5, 4, 5	4,5	7, 8, 7, 6	7,0
P3 – Hypoglycémies chez les patients âgés	3, 4, 3, 2	3,0	9, 8, 9, 8	8,5	5, 5, 4, 6	5,0

- P1 : (6,0 + 2 × 8,0) × 6,0 / 3 = (6,0 + 16,0) × 6,0 / 3 = 132 / 3 = **44,0**.
- P2 : (8,0 + 2 × 4,5) × 7,0 / 3 = 17,0 × 7,0 / 3 = 119 / 3 = **39,7**.
- P3 : (3,0 + 2 × 8,5) × 5,0 / 3 = 20,0 × 5,0 / 3 = 100 / 3 = **33,3**.

Lecture : P1 arrive en tête. P3 a la gravité la plus élevée, mais il touche peu de patients et relève d'abord du suivi médical individuel : le test PEARL (Pertinence pour un projet collectif) peut conduire à l'orienter vers les consultations plutôt que vers le projet.

Astuce – Croiser deux méthodes de priorisation

Quand la méthode de Hanlon et le vote du public (groupe nominal, partie 7.3.9) donnent le même premier problème, la décision est solide. Quand ils divergent, la divergence est un résultat en soi : les professionnels et le public ne voient pas le problème de la même façon. On peut alors retenir le problème prioritaire pour les professionnels en l'abordant par l'entrée choisie par le public, ce qui favorise la participation.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.16

Trois professionnels notent un problème « consommation insuffisante de produits laitiers chez les résidents d'un foyer pour adultes handicapés ». Ampleur : 7, 6, 8 ; gravité : 5, 6, 4 ; efficacité : 8, 7, 9. Calculez les moyennes puis le score de Hanlon. Un quatrième professionnel donne ensuite une gravité de 9 : recalculez le score et commentez.

Corrigé

Moyennes : A = (7 + 6 + 8) / 3 = **7,0** ; B = (5 + 6 + 4) / 3 = **5,0** ; C = (8 + 7 + 9) / 3 = **8,0**. Score : (7,0 + 10,0) × 8,0 / 3 = 136 / 3 = **45,3**. Avec la quatrième note de gravité, B = (5 + 6 + 4 + 9) / 4 = **6,0** ; si A et C ne changent pas, score : (7,0 + 12,0) × 8,0 / 3 = 152 / 3 = **50,7**. Une seule note éloignée fait gagner plus de 5 points : on demande au quatrième professionnel sur quel fait il s'appuie (par exemple, des fractures récentes chez plusieurs résidents), puis le groupe décide en connaissance de cause.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.6 – Définir les priorités

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez cinq critères de priorisation.

2. Écrivez la formule du score de Hanlon et dites quel critère compte double.
3. Calculez le score de Hanlon pour A = 6, B = 7, C = 5.
4. Que signifie chaque lettre du test PEARL, et que se passe-t-il si un critère vaut 0 ?
5. Dans une grille pondérée, à quel moment fixe-t-on les poids ?
6. Notes 4, 5, 3 avec les poids 3, 2, 1 : calculez le score et le pourcentage du maximum.

Corrigé – Point d'étape 7.3.6

1. Ampleur, gravité, efficacité de l'intervention, faisabilité, acceptabilité, cohérence politique, équité (cinq suffisent).
2. Score = (A + 2B) × C / 3 ; la gravité (B) compte double.
3. (6 + 14) × 5 / 3 = 100 / 3 = 33,3.
4. Pertinence, Économie, Acceptabilité, Ressources, Légalité ; un seul 0 écarte le problème.
5. Avant de noter, en groupe, et on les écrit dans le compte rendu.
6. 4 × 3 + 5 × 2 + 3 × 1 = 25 ; maximum 5 × 6 = 30 ; 25 / 30 × 100 = 83,3 %.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 7.3.7.
3 ou 4 sur 6	Je refais le calcul de Hanlon et celui de la grille pondérée.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 7.3.6 et je refais les exercices d'application.

7.3.7 Rédiger les objectifs

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 7.2.2)

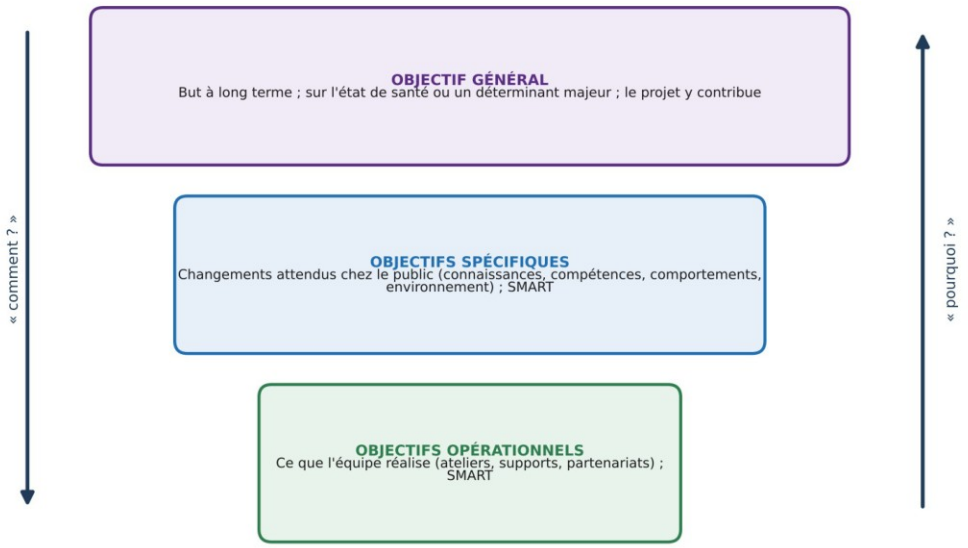


Figure 7.7 – La hiérarchie des objectifs

Comprendre le schéma – Figure 7.7

1. L'**objectif général** exprime le but à **long terme** auquel le projet **contribue** (santé, déterminant majeur) ; il est souvent repris d'une politique (PNNS, CLS) ; il n'est pas mesuré par le seul projet.
2. Les **objectifs spécifiques** décrivent les **changements attendus chez le public** (ou dans son environnement) : connaissances, compétences, attitudes, comportements, accès ; ils correspondent aux

causes choisies dans l'arbre ; ils sont **SMART**.

3. Les **objectifs opérationnels** décrivent ce que l'**équipe** va **réaliser** (nombre d'ateliers, supports, partenariats) ; ils sont aussi SMART et servent à l'évaluation du **processus**.
4. On lit la hiérarchie de haut en bas en se demandant « **comment** ? » et de bas en haut en se demandant « **pourquoi** ? ». Chaque objectif opérationnel doit servir au moins un objectif spécifique.

Définition – Objectif SMART

Spécifique (un seul changement, un public précis) ; **M**esurable (un indicateur et une valeur cible) ; **A**tteignable (ou accepté) au regard des moyens ; **R**éaliste et pertinent (il répond à une cause du diagnostic) ; **T**emporellement défini (une échéance).

Les verbes d'objectifs

Un objectif commence par un **verbe d'action** observable. Pour les objectifs éducatifs, la taxonomie de **Bloom** (1956, révisée par Anderson et Krathwohl en 2001) classe les niveaux cognitifs ; on y ajoute les savoir-faire et les savoir-être.

Domaine	Verbes observables (à préférer à « savoir », « comprendre », « prendre conscience »)
Connaissances (savoir)	Citer, nommer, reconnaître, classer, expliquer, comparer
Compétences (savoir-faire)	Lire (une étiquette), calculer (un coût), préparer, cuisiner, choisir, utiliser
Attitudes (savoir-être)	Exprimer, accepter de goûter, participer, partager
Comportements	Consommer, proposer (de l'eau au goûter), acheter, fréquenter (le marché)

Exemple – Du constat à l'objectif SMART : calcul de la valeur cible

Constat : au début du cycle, 3 familles sur 12 (25 %) consomment des légumes secs au moins 2 fois par semaine. **Objectif spécifique** : « D'ici fin mai 2028, au moins 60 % des familles participantes déclarent consommer des légumes secs au moins 2 fois par semaine. »

- Valeur cible en effectif : 60 % × 12 = 0,60 × 12 = 7,2 → **8 familles** au moins (on arrondit au supérieur pour atteindre 60 %).
- Progression attendue : 60 − 25 = **35 points** ; variation relative : (60 − 25) / 25 × 100 = **+ 140 %**.

Objectif opérationnel : « Animer 6 ateliers de 3 heures de mars à mai 2028 pour 12 familles, avec un taux de présence d'au moins 80 %. »

- Présences possibles : 6 × 12 = **72** ; cible : 0,80 × 72 = 57,6 → **58 présences** au moins.

Vérification SMART : S (légumes secs, familles participantes), M (60 %, questionnaire avant/après), A (3 ateliers sur 6 portent sur les légumes secs ; recettes à moins de 1,50 € par personne), R (cause « compétences culinaires » + constat de l'épicerie), T (fin mai 2028).

Objectif mal formulé	Objectif reformulé (SMART)
« Sensibiliser les familles à l'équilibre alimentaire »	« À la fin du cycle, au moins 75 % des participants citent 3 repères du PNNS (score au questionnaire) »
« Faire des ateliers »	« Animer 6 ateliers culinaires entre mars et mai 2028 pour 12 familles »
« Que les enfants mangent mieux »	« D'ici fin mai 2028, réduire de moitié la proportion de familles qui proposent une boisson sucrée au goûter (de 46 % à 23 % au plus) »

Objectif mal formulé	Objectif reformulé (SMART)
« Améliorer les connaissances »	« À la fin du cycle, le score moyen de connaissances des participants sur l'alimentation à petit budget atteint au moins 7/10 (contre 4,75/10 au début) »

L'arbre à objectifs

L'**arbre à objectifs** est la transformation **positive** de l'arbre à problèmes : le problème central devient l'objectif général (ou un objectif spécifique principal), chaque cause retenue devient un objectif spécifique, et les conséquences deviennent les effets attendus à long terme. Les causes non retenues apparaissent en grisé, avec la justification (hors champ, déjà traité par un partenaire, plaidoyer).

À vous de jouer – Exercice d'application 7.17

Transformez en objectifs spécifiques SMART les causes suivantes issues d'un diagnostic en résidence autonomie (40 résidents) : a) 15 résidents disent « ne plus avoir envie de cuisiner pour une seule personne » ; b) 9 résidents ne savent pas où trouver des produits frais à proximité depuis la fermeture de l'épicerie.

Corrigé

a) « D'ici 6 mois, au moins 10 des 15 résidents concernés participent au moins 2 fois par mois au repas partagé de la résidence (feuilles de présence). » Calcul : 10 / 15 = 66,7 %, cible réaliste pour une activité facultative. **b)** « D'ici 3 mois, au moins 7 des 9 résidents concernés connaissent et utilisent au moins une solution d'approvisionnement en produits frais (marché, livraison, panier solidaire) (questionnaire). » Calcul : 7 / 9 = 77,8 %. Ces objectifs portent sur des changements **chez les résidents** ; les objectifs opérationnels correspondants seraient : organiser un repas partagé bimensuel ; réaliser un guide des ressources d'approvisionnement.

Associer un indicateur à chaque objectif

Un objectif n'est mesurable que s'il est accompagné d'un **indicateur**, d'une **valeur initiale** et d'une **valeur cible**. L'indicateur dit **ce que l'on mesure** ; la valeur initiale, mesurée pendant le diagnostic ou au premier atelier, dit **d'où l'on part** ; la valeur cible dit **où l'on veut arriver**. L'évaluation, traitée au chapitre 9, comparera la valeur finale à ces deux valeurs.

Niveau d'objectif	Type d'indicateur	Exemple d'indicateur	Outil de mesure
Objectif général	Indicateur d'impact (long terme, rarement mesuré par le projet seul)	Prévalence du surpoids des enfants du quartier	Données de santé scolaire, PMI
Objectif spécifique	Indicateur de résultat (changement chez le public)	Part des familles qui consomment des légumes secs au moins 2 fois par semaine	Questionnaire avant et après
Objectif opérationnel	Indicateur de processus (ce que l'équipe a réalisé)	Nombre d'ateliers animés ; taux de présence	Planning, feuilles de présence

Définition – Les qualités d'un bon indicateur

Un bon indicateur est **valide** (il mesure vraiment ce que l'objectif vise), **fiable** (deux personnes qui le mesurent trouvent le même résultat), **sensible** (il bouge si la situation change), **disponible** (on peut le recueillir avec les moyens du projet) et **compréhensible** par les partenaires. On en choisit un ou deux par objectif, pas davantage.

Méthode pas à pas – Rédiger la fiche d'un indicateur

Pour chaque indicateur, on écrit sur une ligne : le **nom** (part des familles qui…) ; le **mode de calcul** (numérateur / dénominateur × 100) ; la **source** et l'**outil** (questionnaire, question n° 6) ; le **moment** de la mesure (premier et dernier atelier) ; la **personne** qui le recueille ; la **valeur initiale** et la **valeur cible**. Cette fiche évite qu'on change de mode de calcul entre le début et la fin du projet.

Nom	Calcul	Outil	Moments	Valeur initiale	Valeur cible
Familles consommant des légumes secs ≥ 2 fois par semaine	Familles répondant « 2 fois ou plus » / familles répondantes × 100	Questionnaire, question 6	Atelier 1 et atelier 6	25 % (3 sur 12)	60 % (8 sur 12)
Taux de présence aux ateliers	Présences / (ateliers × familles inscrites) × 100	Feuilles de présence	À chaque atelier	Sans objet	80 % (58 présences sur 72)

Exemple – Calcul détaillé : fixer une cible à partir d'une valeur initiale

Dans un service de soins de suite (fictif), 14 patients sur 35 savent choisir un petit-déjeuner riche en protéines à l'entrée du programme, soit 14 / 35 × 100 = **40,0 %**. L'équipe vise 70 % à la sortie : 0,70 × 35 = 24,5, soit **25 patients** au moins (on arrondit au supérieur). À la sortie, 25 patients réussissent : 25 / 35 × 100 = **71,4 %**, la cible est atteinte. Si l'équipe avait seulement écrit « améliorer les connaissances », personne n'aurait pu dire si le projet avait réussi.

Attention – Indicateur de processus et indicateur de résultat

« 6 ateliers animés » prouve que l'équipe a travaillé, pas que le public a changé. Un dossier qui ne présente que des indicateurs de processus ne permet pas de juger l'efficacité. À l'inverse, un dossier sans indicateurs de processus ne permet pas de comprendre pourquoi un résultat n'est pas atteint (ateliers annulés, faible présence). Les deux types sont nécessaires.

Fixer une valeur cible réaliste

Une valeur cible trop ambitieuse condamne le projet à « échouer » ; une valeur trop modeste ne convainc pas le financeur. Pour fixer une cible réaliste, on s'appuie sur quatre éléments.

1. La valeur initiale. On ne peut pas viser + 30 points si 85 % du public fait déjà ce que l'on souhaite. Plus la valeur initiale est haute, plus le gain possible est petit.

2. Les résultats d'actions comparables. Le portail des interventions probantes, les rapports d'évaluation d'autres structures et la littérature donnent des ordres de grandeur (partie 7.4.3 et chapitre 19).

3. L'intensité de l'action. Deux ateliers ne changent pas un comportement installé ; un cycle de six ateliers avec un suivi peut le faire. La cible doit être proportionnée au nombre de séances et à leur durée.

4. Les personnes perdues de vue. Dans un cycle d'ateliers, certains participants ne viennent pas au dernier atelier. On calcule donc la cible sur les personnes présentes aux deux mesures, et on l'annonce.

Exemple – Calcul détaillé : une cible qui tient compte des perdus de vue

Un cycle de nutrition pour 45 personnes âgées vivant à domicile (fictif) commence en octobre. À la première séance, 18 personnes sur 45 (**40,0 %**) déclarent consommer un produit laitier à chaque repas. L'équipe vise **60 %**, soit 0,60 × 45 = **27 personnes**. Au dernier atelier, 36 personnes sont présentes (36 / 45 × 100 = **80,0 %** des inscrits), et 27 d'entre elles déclarent un produit laitier à chaque repas, soit 27 / 36 × 100 = **75,0 %** des présents.

Lecture : la cible de 60 % est atteinte chez les présents. Mais on ne connaît pas la situation des 9 absents. Le dossier présente les deux chiffres et écrit honnêtement la limite : « 75,0 % des 36 participants présents à la

dernière séance ; les 9 personnes absentes n'ont pas pu être réinterrogées. »

Astuce – Écrire la cible en effectif quand le groupe est petit

Avec 12 familles, « passer de 25 % à 60 % » se lit mieux « passer de 3 à au moins 8 familles ». L'effectif rappelle au lecteur que chaque famille compte pour plus de 8 points de pourcentage, et il évite de donner une fausse impression de précision.

Erreur dans un objectif	Exemple	Correction
Cible sans valeur initiale	« 70 % des élèves prendront un petit-déjeuner »	« De 45 % (mesure de septembre) à au moins 70 % en juin »
Indicateur qui ne mesure pas l'objectif	Objectif sur la consommation, indicateur « satisfaction des participants »	Indicateur : part des participants qui consomment… (questionnaire de fréquence)
Échéance absente	« Augmenter la part des familles qui… »	« D'ici fin mai 2028, … »
Plusieurs changements dans un objectif	« Connaître les repères et consommer plus de légumes »	Deux objectifs : un de connaissances, un de comportement
Cible impossible à vérifier	« Tous les enfants mangeront mieux »	« Le taux de restes de légumes passera de 41 % à 30 % au plus (pesée sur 3 jours) »

À vous de jouer – Exercice d'application 7.18

Dans un foyer de travailleurs migrants, 18 résidents sur 45 déclarent prendre au moins un repas avec des légumes par jour. L'équipe veut atteindre 60 % en six mois avec quatre ateliers de cuisine collective. a) Calculez la valeur initiale en pourcentage et la cible en effectif. b) Calculez la progression en points et la variation relative. c) Rédigez l'objectif spécifique complet avec son indicateur et son outil.

Corrigé

a) Valeur initiale : 18 / 45 × 100 = **40,0 %** ; cible : 0,60 × 45 = **27 résidents** au moins. b) Progression : 60 − 40 = **20 points** ; variation relative : (60 − 40) / 40 × 100 = **+ 50 %**. c) « D'ici [date à six mois], au moins 60 % des résidents participants (27 sur 45) déclarent prendre au moins un repas comportant des légumes chaque jour (questionnaire de fréquence passé au premier et au dernier atelier ; valeur initiale 40,0 %). » On pourra discuter le réalisme de la cible : quatre ateliers en six mois restent une action courte.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.7 – Rédiger les objectifs

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que signifient les cinq lettres de SMART ?
2. Sur qui porte un objectif spécifique ? Sur qui porte un objectif opérationnel ?
3. Associez un type d'indicateur à chaque niveau d'objectif.
4. Citez trois qualités d'un bon indicateur.
5. 9 personnes sur 30 au départ, cible 50 % : combien de personnes au moins faut-il atteindre ?
6. Pourquoi faut-il préciser le nombre de personnes présentes à la mesure finale ?
7. Reformulez « Sensibiliser les enfants aux fruits » en objectif SMART.

Corrigé – Point d'étape 7.3.7

1. Spécifique, Mesurable, Atteignable (ou accepté), Réaliste et pertinent, Temporellement défini.

2. L'objectif spécifique porte sur le public (un changement chez lui) ; l'objectif opérationnel porte sur l'équipe (ce qu'elle réalise).

3. Général : indicateur d'impact ; spécifique : indicateur de résultat ; opérationnel : indicateur de processus.

4. Valide, fiable, sensible, disponible, compréhensible (trois suffisent).

5. 0,50 × 30 = 15 personnes.

6. Parce que des participants peuvent être perdus de vue : le pourcentage final n'a pas la même base que le pourcentage initial.

7. Exemple : « D'ici juin 2028, au moins 70 % des enfants de la classe (contre 40 % en septembre) goûtent les trois fruits proposés lors de l'atelier de dégustation (grille d'observation). »

Mon score	Ce que je fais
7 ou 6 sur 7	Je passe à la partie 7.3.8.
4 ou 5 sur 7	Je relis la fiche d'un indicateur et le tableau des erreurs dans un objectif.
Moins de 4 sur 7	Je relis toute la partie 7.3.7 et je refais les exercices d'application.

7.3.8 Choisir un échantillon en pratique

Module · Référentiel : C3.3, C3.4 · CNED : pas de passage correspondant (voir 7.2.2)

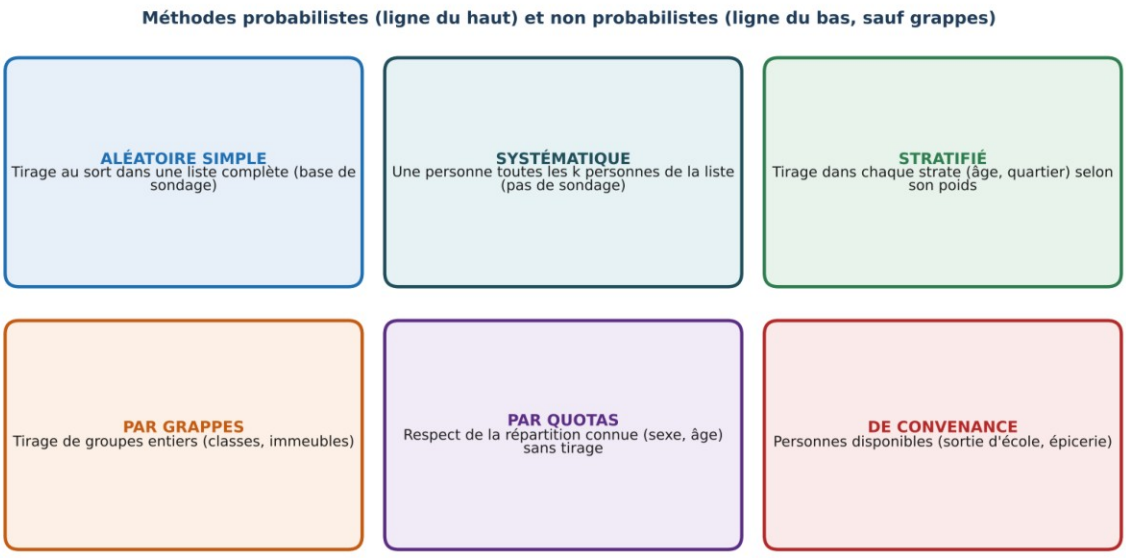


Figure 7.13 – Les principales méthodes d'échantillonnage

Comprendre le schéma – Figure 7.13

1. Aléatoire simple : chaque personne de la population a la même probabilité d'être tirée ; nécessite une **base de sondage** (liste complète : élèves d'un collège, adhérents d'une épicerie).

2. Systématique : on tire au hasard un point de départ, puis une personne toutes les **k** personnes de la liste (k = taille de la population / taille de l'échantillon, appelé **pas de sondage**).

3. Stratifié : la population est divisée en **strates** (classes d'âge, quartiers, niveaux scolaires) et l'on tire dans chacune, en général proportionnellement à son poids ; il garantit la représentation de chaque groupe.

4. Par grappes : on tire des groupes entiers (classes, immeubles, structures) et l'on interroge toutes les personnes de chaque groupe tiré ; pratique sur le terrain, moins précis.

5. Par quotas : on reproduit la répartition connue de la population (sexe, âge, quartier) sans tirage au sort ; très utilisé par les instituts de sondage.

6. De convenance : on interroge les personnes disponibles ; c'est souvent la seule méthode possible en stage, mais elle expose au **biais de sélection** : on la décrit honnêtement et on diversifie les lieux.

Exemple – Calcul détaillé : un échantillon stratifié dans un collège

Un collège compte 520 élèves : 6e : 140 ; 5e : 130 ; 4e : 128 ; 3e : 122. On veut interroger **130 élèves** (soit 25 %), répartis proportionnellement.

- Taux de sondage : 130 / 520 = **0,25**.
- 6e : 140 × 0,25 = **35** ; 5e : 130 × 0,25 = **32,5**, soit 32 ou 33 ; 4e : 128 × 0,25 = **32** ; 3e : 122 × 0,25 = **30,5**, soit 30 ou 31.
- Arrondis pour obtenir 130 : 35 + 33 + 32 + 30 = **130** (vérifié).
- **Tirage systématique dans chaque niveau** (6e) : pas de sondage k = 140 / 35 = **4** ; on tire au hasard un nombre entre 1 et 4 (par exemple 3) et l'on interroge les élèves n° 3, 7, 11, 15… de la liste alphabétique (3 + 4 × 34 = 139, dernier élève tiré).

Intérêt : chaque niveau est représenté selon son poids ; la marge d'erreur pour une proportion de 50 % sur 130 élèves est d'environ 1,96 × √(0,25 / 130) = 1,96 × 0,0439 = **0,086**, soit ± 8,6 points (un peu moins avec la stratification et la correction pour population finie).

Exemple – Calcul détaillé : construire des quotas

Dans un quartier, l'Insee indique : 52 % de femmes ; 28 % de moins de 30 ans, 47 % de 30 à 59 ans, 25 % de 60 ans ou plus. Pour 80 questionnaires par quotas :

- Femmes : 0,52 × 80 = **41,6**, soit **42** ; hommes : 80 − 42 = **38**.
- Moins de 30 ans : 0,28 × 80 = **22,4**, soit **22** ; 30-59 ans : 0,47 × 80 = **37,6**, soit **38** ; 60 ans ou plus : 0,25 × 80 = **20** ; total 22 + 38 + 20 = **80** (vérifié).
- Les enquêteurs suivent l'avancement des quotas et ciblent les profils manquants (par exemple, les hommes de moins de 30 ans, souvent sous-représentés dans les enquêtes de jour).

Quand la population est petite : la correction pour population finie

La formule n = 1,96² × p × (1 − p) / e² (partie 7.3.3) suppose une population très grande. En stage, la population est souvent petite : 520 élèves d'un collège, 180 résidents d'un établissement, 60 bénéficiaires d'une épicerie. Dans ce cas, il faut interroger moins de personnes que ce que donne la formule. On applique la **correction pour population finie**.

Méthode pas à pas – Taille d'échantillon dans une population de taille N

1. Calculer la taille n pour une grande population : n = 1,96² × p × (1 − p) / e² (avec p = 0,5 si l'on ne sait rien).

2. Corriger : **n' = n / (1 + (n − 1) / N)**, où N est la taille de la population.

3. Arrondir n' à l'entier **supérieur**.

4. Prévoir les non-réponses : si l'on attend 70 % de réponses, on sollicite n' / 0,70 personnes.

La correction compte peu quand N est grand (au-delà de 20 fois n), et beaucoup quand N est petit.

Exemple – Calcul détaillé : un collège de 520 élèves

Pour une marge de ± 5 points avec p inconnu : n = 385 (partie 7.3.3).

- n' = 385 / (1 + (385 − 1) / 520) = 385 / (1 + 384 / 520) = 385 / (1 + 0,738) = 385 / 1,738 = **221,5**, soit **222 élèves**.
- Pour ± 10 points : n = 97 ; n' = 97 / (1 + 96 / 520) = 97 / 1,185 = **81,9**, soit **82 élèves**.

- Si l'on attend 75 % de réponses : 222 / 0,75 = **296 élèves** à solliciter pour ± 5 points.

Comparaison : dans une ville de 20 000 habitants, la correction donne 385 / (1 + 384 / 20 000) = **377,7**, soit 378 : presque rien ne change. Dans un établissement de 180 résidents, elle donne 385 / (1 + 384 / 180) = **122,9**, soit 123 : plus des deux tiers des résidents.

Taille de la population N	Échantillon pour ± 5 points	Échantillon pour ± 10 points
180	123	64
520	222	82
1 200	292	90
20 000	378	97

Attention – Une petite population, c'est souvent tout le monde

Avec 60 bénéficiaires d'une épicerie, l'échantillon calculé pour ± 10 points est de 97 / (1 + 96 / 60) = 37,3, soit 38 personnes : près des deux tiers du groupe. Il est alors plus simple et plus juste de proposer le questionnaire à **tout le monde** (on parle d'enquête exhaustive) et de suivre le taux de réponse. La marge d'erreur ne concerne plus le tirage, mais les non-répondants restent une source de biais.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.19

Un établissement accueille 180 résidents. La diététicienne veut estimer, à ± 10 points près, la part des résidents qui ne finissent pas leur plat du soir. a) Calculez la taille d'échantillon sans correction, puis avec correction. b) Elle prévoit que 80 % des résidents tirés au sort pourront répondre : combien doit-elle en tirer ?

Corrigé

a) Sans correction : n = $1{,}96^2 \times 0{,}5 \times 0{,}5 / 0{,}10^2$ = 0,9604 / 0,01 = 96,04, soit **97**. Avec correction : n' = 97 / (1 + 96 / 180) = 97 / 1,533 = **63,3**, soit **64 résidents**. b) 64 / 0,80 = **80 résidents** à tirer au sort. Dans un établissement, une observation des plateaux de tous les résidents pendant trois soirs serait une autre solution, plus fiable que des réponses déclaratives.

Tirer au sort avec un tableur

Le tirage au sort paraît compliqué, mais un tableur suffit. Il faut seulement disposer d'une **base de sondage** : la liste complète des personnes de la population (liste des élèves, des adhérents, des résidents), sans noms si possible, avec un simple numéro.

Méthode pas à pas – Tirage aléatoire simple en quatre gestes

1. Coller la liste des numéros dans la colonne A (une personne par ligne).

2. Écrire dans la colonne B la fonction qui donne un nombre au hasard (ALEA dans un tableur en français) et la recopier sur toutes les lignes.

3. Figer les valeurs (copier, puis coller les valeurs seulement), sinon elles changent à chaque calcul.

4. Trier le tableau selon la colonne B, puis retenir les n premières lignes. Conserver le fichier : il prouve que le tirage a été fait au hasard.

Le tirage par grappes

Quand il n'existe pas de liste des personnes, mais une liste de **groupes** (classes, étages, structures), on tire au sort des groupes entiers, puis on interroge toutes les personnes des groupes tirés. C'est le **sondage par grappes** (figure 7.13). Il est pratique, car on se déplace dans peu de lieux. Il est moins précis qu'un tirage simple de même taille, car les personnes d'un même groupe se ressemblent (même enseignant, même horaire de cantine).

Exemple – Calcul détaillé : quatre classes sur douze

Une école primaire compte 12 classes d'environ 25 élèves, soit à peu près 300 élèves. On tire au sort 4 classes : le taux de sondage est 4 / 12 = **33,3 %**. On interroge les 100 élèves de ces classes, soit 100 / 300 × 100 = **33,3 %** des élèves. Pour limiter l'effet « classe », on peut d'abord ranger les classes par niveau (CP-CE1, CE2-CM1, CM2) et tirer au moins une classe dans chaque niveau : c'est un tirage par grappes **stratifié**.

Que faire des refus et des absents ?

Une personne tirée au sort peut refuser de répondre ou être absente. Deux règles évitent de fausser l'échantillon. D'abord, on **relance** les absents (un second passage, un autre horaire) avant de les remplacer. Ensuite, si l'on remplace, on tire le remplaçant **au hasard** dans la liste restante, et l'on ne choisit jamais « quelqu'un de disponible ». Dans le dossier, on donne le nombre de personnes tirées, de répondants et de refus.

Étape	Effectif	Pourcentage
Personnes tirées au sort	120	100,0 %
Absentes après deux passages	14	11,7 %
Refus	9	7,5 %
Répondants	97	80,8 %

Lien diététique – Le tirage au sort et l'éthique

Le tirage au sort est juste : chacun a la même chance d'être interrogé. Il ne doit pourtant pas devenir une obligation de répondre. On rappelle à chaque personne tirée qu'elle peut refuser sans conséquence, conformément aux règles d'information et de consentement du chapitre 6, et l'on ne transmet pas à la structure la liste nominative de ceux qui ont refusé.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.20

Un service de portage de repas livre 340 personnes, réparties en 17 tournées de 20 personnes. La diététicienne veut interroger environ 80 personnes. a) Proposez un tirage par grappes : combien de tournées faut-il tirer ? b) Proposez un tirage systématique dans la liste complète : quel est le pas de sondage ? c) Quelle méthode conseillez-vous, et pourquoi ?

Corrigé

a) 80 / 20 = **4 tournées** tirées au sort (taux de sondage 4 / 17 = **23,5 %**). b) Pas de sondage : 340 / 80 = **4,25** ; on retient un pas de 4, ce qui donne 85 personnes, ou l'on prend une personne sur 4 jusqu'à 80. c) Le tirage systématique est plus précis, car les personnes d'une même tournée habitent le même secteur et se ressemblent. Le tirage par grappes est plus simple si la diététicienne accompagne les livreurs. Dans les deux cas, on prévoit des visites à domicile adaptées aux personnes âgées.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.8 – Choisir un échantillon

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qu'une base de sondage ?
2. Citez les six méthodes d'échantillonnage de la figure 7.13.
3. Une liste de 300 élèves, un échantillon de 60 : quel est le pas de sondage ?
4. Écrivez la formule de la correction pour population finie.
5. n = 97 et N = 520 : calculez n'.
6. Pourquoi ne remplace-t-on pas un absent par « quelqu'un de disponible » ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.8

1. La liste complète des personnes de la population, dans laquelle on tire l'échantillon.
2. Aléatoire simple, systématique, stratifié, par grappes, par quotas, de convenance.
3. 300 / 60 = 5 : une personne sur cinq.
4. n' = n / (1 + (n − 1) / N).
5. 97 / (1 + 96 / 520) = 97 / 1,185 = 81,9, soit 82.
6. Parce que les personnes disponibles ne ressemblent pas aux autres (biais de sélection) ; on relance, puis on tire le remplaçant au hasard.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 7.3.9.
3 ou 4 sur 6	Je refais le calcul de la correction pour population finie.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 7.3.8 et je refais les exercices d'application.

7.3.9 Les méthodes participatives de diagnostic

Module · Référentiel et guide : voir 7.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 7.2.2)

Le diagnostic n'est pas seulement une collecte d'informations **sur** les personnes : il peut être construit **avec** elles (diagnostic partagé, 7.4.2). Ces méthodes recueillent des données qualitatives riches et renforcent la participation.

Méthode	Déroulement	Points de vigilance
Photo-expression (photolangage)	Les participants choisissent parmi des photos celles qui évoquent pour eux le thème (« bien manger ») et expliquent leur choix	Choisir des photos variées, non stigmatisantes, culturellement diverses
Photovoice	Les habitants photographient eux-mêmes ce qui, dans leur quotidien, aide ou freine le fait de bien manger, puis discutent les photos en groupe	Droit à l'image des tiers ; temps (plusieurs séances) ; restitution aux élus
Marche exploratoire	Parcours du quartier en petit groupe avec une grille : commerces, prix, accès, espaces de jeux, sentiment de sécurité	Préparer l'itinéraire ; accessibilité ; compte rendu
Cartographie participative	Sur un plan du quartier, les habitants placent les lieux d'achat, de repas, de rencontre et les « zones blanches »	Plan lisible, gommettes de couleurs
World café	Petites tables de discussion sur des questions différentes, les participants changent de table ; un hôte par table synthétise	Questions courtes, synthèse finale collective

Méthode	Déroulement	Points de vigilance
Arbre à problèmes collectif	Construction de l'arbre avec les habitants et partenaires (7.3.5)	Animation neutre, chaque cause appuyée par un fait ou un témoignage

Prioriser en groupe : la technique du groupe nominal

Méthode pas à pas – Technique du groupe nominal (Delbecq et Van de Ven, 1971)

1. Question posée au groupe (6 à 12 personnes) : « Quels sont les principaux problèmes d'alimentation des familles du quartier ? »

2. Réflexion individuelle silencieuse (5 à 10 minutes) : chacun écrit ses idées.

3. Tour de table : chaque participant énonce une idée à la fois, notée au tableau, sans discussion, jusqu'à épuisement.

4. Clarification des idées, regroupement des doublons.

5. Vote individuel : chacun choisit les 5 problèmes qu'il juge prioritaires et leur attribue des points (5 au plus important, 1 au moins important).

6. Calcul des scores et classement, puis discussion du résultat. Avantage : chaque personne s'exprime, y compris les plus discrètes ; la décision n'est pas captée par les plus influents.

Exemple – Calcul détaillé : un vote en groupe nominal (8 participants)

Problème	Somme des points	Nombre de votants	Score moyen par votant
Le coût des fruits et légumes	31	8	3,9
Les enfants refusent les légumes	26	7	3,7
Ne pas savoir cuisiner les légumes secs	22	6	3,7
Les sodas et les goûters industriels	18	6	3,0
Le manque de temps	15	5	3,0
L'absence de marché dans le quartier	8	4	2,0

- Total des points distribués : 8 participants × (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 8 × 15 = **120** ; vérification : 31 + 26 + 22 + 18 + 15 + 8 = **120** (vérifié).
- Part des points du premier problème : 31 / 120 × 100 = **25,8 %**.
- Score moyen par votant (somme / nombre de votants) : 31 / 8 = **3,9** ; 26 / 7 = **3,7** ; 22 / 6 = **3,7**.

Lecture : le coût arrive en tête ; les trois premiers problèmes totalisent (31 + 26 + 22) / 120 × 100 = **65,8 %** des points. Le résultat du groupe nominal est **croisé** avec la méthode de Hanlon (7.3.6) et les données objectives : les deux approches convergent ici vers les légumes secs et le budget.

Jusqu'où faire participer ? Les degrés de participation au diagnostic

Faire participer le public ne veut pas toujours dire la même chose. L'échelle d'Arnstein, présentée au chapitre 6, distingue l'information, la consultation, la concertation et le pouvoir de décision partagé. Pour un diagnostic de stage, on peut retenir trois degrés réalistes.

Degré	Ce que fait le public	Exemple en diagnostic	Ce que cela demande
Consultation	Il répond à des questions préparées par l'équipe	Questionnaire, entretien	Peu de temps ; le public ne voit pas toujours la suite
Concertation	Il discute les résultats et donne son avis sur les priorités	Restitution, groupe nominal, vote	Une ou deux réunions ; une animation neutre

Degré	Ce que fait le public	Exemple en diagnostic	Ce que cela demande
Coconstruction	Il recueille lui-même des informations et participe aux décisions	Photovoice, marche exploratoire menée par des habitants, habitants membres du comité de pilotage	Plusieurs séances ; un engagement de l'équipe à tenir compte des décisions

Attention – La participation « alibi »

Réunir des habitants pour les écouter, puis décider sans eux et sans leur expliquer pourquoi leur avis n'a pas été suivi, décourage la participation suivante. Avant de proposer un temps participatif, l'équipe décide ce qui est **réellement ouvert** à la discussion (le choix des thèmes d'ateliers, les horaires) et ce qui ne l'est pas (le budget, déjà fixé par le financeur), et elle le dit clairement.

Animer une marche exploratoire

La marche exploratoire est un parcours du quartier en petit groupe (quatre à huit personnes, dont des habitants) pour observer l'environnement alimentaire avec leurs yeux. Elle complète le repérage de l'offre (partie 7.3.10) par le **vécu** : un commerce peut exister à 300 mètres et rester inaccessible (escaliers, horaires, sentiment d'insécurité).

Méthode pas à pas – Préparer et mener la marche

1. Tracer l'itinéraire avec les habitants : les trajets réels (école, arrêt de bus, commerces), pas un circuit idéal. Durée : 60 à 90 minutes.

2. Préparer une grille simple : pour chaque arrêt, ce qu'on y trouve, les prix de quelques produits repères, l'accès (trottoirs, poussettes, fauteuils), les horaires, ce que les habitants en disent.

3. Répartir les rôles : un guide habitant, un preneur de notes, un photographe (photos sans personnes reconnaissables).

4. Débriefer juste après, autour d'un plan : points forts, points faibles, idées d'amélioration.

5. Restituer une carte annotée aux participants et aux élus.

Exemple – Calcul détaillé : synthèse de la grille de marche

Une marche dans un quartier (fictif) compte 10 arrêts. Les 6 participants notent chaque arrêt de 1 (très difficile d'accès) à 4 (très facile d'accès). L'arrêt « supérette » obtient les notes 3, 4, 3, 2, 3, 3 ; l'arrêt « marché du jeudi » obtient 2, 1, 2, 2, 1, 2.

- Supérette : (3 + 4 + 3 + 2 + 3 + 3) / 6 = 18 / 6 = **3,0** sur 4.
- Marché : (2 + 1 + 2 + 2 + 1 + 2) / 6 = 10 / 6 = **1,7** sur 4.

Lecture : le marché, où les produits frais sont les moins chers, est jugé difficile d'accès. Les commentaires expliquent pourquoi : il se tient le jeudi matin, pendant les heures de travail, et il faut traverser une route sans passage piéton. Ce résultat oriente vers une action de plaidoyer (horaire du marché, aménagement) plutôt que vers une action d'éducation.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.21

Vous préparez un diagnostic participatif avec les jeunes d'une maison des lycéens. Pour chacune des trois activités suivantes, indiquez le degré de participation (consultation, concertation ou coconstruction) et une précaution à prendre : a) un questionnaire en ligne sur le petit-déjeuner ; b) un photovoice sur « ce qui m'aide ou m'empêche de bien manger au lycée » ; c) un vote sur les trois actions prioritaires parmi six proposées par l'équipe.

Corrigé

a) **Consultation**. Précaution : informer sur le traitement des données et l'anonymat ; vérifier que les élèves sans accès facile à internet peuvent répondre (version papier). b) **Coconstruction**. Précaution : droit à l'image (aucune personne reconnaissable sans accord), plusieurs séances, restitution des photos aux décideurs avec les lycéens. c) **Concertation**. Précaution : annoncer avant le vote ce que l'équipe fera du résultat, et expliquer ensuite pourquoi une action n'a pas été retenue si c'est le cas.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.9 – Les méthodes participatives

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la différence entre le photolangage et le photovoice ?
2. Citez les six étapes de la technique du groupe nominal.
3. Huit participants votent avec 5, 4, 3, 2 et 1 points : combien de points sont distribués au total ?
4. Citez les trois degrés de participation réalistes en stage.
5. Qu'est-ce qu'une participation « alibi » ?
6. Que doit contenir la grille d'une marche exploratoire ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.9

1. Dans le photolangage, les participants choisissent parmi des photos proposées ; dans le photovoice, ils prennent eux-mêmes les photos de leur quotidien.
2. Question, réflexion individuelle silencieuse, tour de table, clarification, vote individuel, calcul et discussion.
3. 8 × 15 = 120 points.
4. Consultation, concertation, coconstruction.
5. On fait parler le public puis l'on décide sans lui, sans expliquer ce que l'on a fait de son avis.
6. Pour chaque arrêt : ce qu'on y trouve, quelques prix, l'accès, les horaires et ce qu'en disent les habitants.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 7.3.10.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau des méthodes participatives et celui des degrés.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 7.3.9 et je refais l'exercice d'application.

7.3.10 Analyser l'environnement alimentaire d'un territoire

Module · Référentiel et guide : voir 7.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 7.2.2)

L'**environnement alimentaire** (chapitre 2) est un déterminant majeur ; son analyse objective le diagnostic au-delà des déclarations.

Indicateur	Calcul ou méthode	Source
Densité de commerces alimentaires	Nombre de commerces / population × 1 000 (ou par km²)	Repérage, base permanente des équipements (Insee), cartes
Distance au commerce de fruits et légumes le plus proche	Distance à pied (en mètres) ou temps en transport	Cartographie en ligne, marche exploratoire
Indice d'environnement alimentaire (type mRFEI)	Commerces proposant des produits favorables à la santé / (favorables + défavorables) × 100	Repérage (méthode des Centers for Disease Control, États-Unis, 2011, adaptable)
Prix d'un panier de référence	Coût d'une liste fixe de produits dans plusieurs commerces	Relevé de prix (7.3.14, fil rouge)

Indicateur	Calcul ou méthode	Source
Offre de restauration rapide autour des écoles	Nombre d'établissements dans un rayon de 500 m	Repérage, annuaires
Accès à l'aide alimentaire	Structures, horaires, conditions d'accès	CCAS, associations

Définition – Désert et marais alimentaires

Un **désert alimentaire** est un territoire où l'accès à des produits frais et abordables est difficile (éloignement, absence de commerce, transports insuffisants). Un **marais alimentaire** est un territoire où l'offre est abondante mais dominée par des produits peu favorables à la santé (restauration rapide, supérettes proposant surtout des produits transformés), qui « noient » l'offre favorable. En France, les quartiers prioritaires et certaines zones rurales cumulent parfois ces deux situations.

Exemple – Calcul détaillé : l'environnement alimentaire du quartier des Tilleuls

Repérage dans un rayon de 800 m : commerces proposant des fruits et légumes frais et des produits de base : supérette (1), épicerie solidaire (1), primeur (0) ; commerces proposant surtout des produits défavorables : restaurants rapides (3), boulangerie-snacking (1), bureau de tabac avec confiserie (1).

- Indice d'environnement favorable : 2 / (2 + 5) × 100 = 2 / 7 × 100 = **28,6** (sur 100).
- Densité de commerces alimentaires : 7 commerces / 4 200 habitants × 1 000 = **1,67 pour 1 000 habitants**.
- Ratio restauration rapide / commerces de produits frais : 3 / 2 = **1,5**.

Lecture : le quartier présente les caractéristiques d'un **marais alimentaire** (offre défavorable plus de deux fois plus fréquente que l'offre favorable) avec une offre de produits frais limitée ; cela justifie le partenariat avec l'épicerie solidaire, la visite du marché et un plaidoyer auprès de la commune (marché de plein vent dans le quartier).

Le relevé de prix d'un panier de référence

Le relevé de prix rend visible une inégalité d'accès : selon le commerce, le même panier ne coûte pas le même prix. On compare un **panier de référence**, c'est-à-dire une liste fixe de produits courants, de formats identiques, dans plusieurs commerces du territoire. Le fil rouge (partie 7.3.14) en donne un extrait ; voici la méthode complète.

Méthode pas à pas – Construire et relever un panier de référence

1. Choisir 8 à 15 produits de base, favorables à la santé et consommés par le public : légumes secs, féculents complets, légumes et fruits de saison, produits laitiers, œufs, poisson en conserve.

2. Fixer pour chaque produit un **format** et une **qualité** (marque de distributeur, premier prix ou vrac) : on compare des produits identiques.

3. Relever dans 3 à 5 commerces fréquentés par le public, le même jour ou la même semaine, en notant les ruptures de stock.

4. Calculer le total du panier dans chaque commerce, puis l'écart en pourcentage par rapport au commerce de proximité.

5. Dater et décrire la méthode : les prix changent vite, et un relevé sans date n'a aucune valeur.

Exemple – Calcul détaillé : un panier de huit produits dans trois commerces

Relevé fictif réalisé la même semaine dans une supérette de quartier, un supermarché situé à 2,5 km et un marché de plein vent.

Produit (format)	Supérette (€)	Supermarché (€)	Marché (€)
Lentilles vertes sèches (500 g)	2,40	1,95	1,80
Riz long (1 kg)	2,20	1,65	1,90
Carottes (1 kg)	2,10	1,40	1,20
Pommes (1 kg)	3,20	2,40	2,10
Lait demi-écrémé (1 L)	1,25	0,99	0,95
Œufs (boîte de 6)	2,30	1,85	2,00
Pain complet (400 g)	2,10	1,60	1,75
Sardines à l'huile (135 g)	1,90	1,35	1,20
Total du panier	17,45	13,19	12,90

- Écart du supermarché : (13,19 − 17,45) / 17,45 × 100 = − 4,26 / 17,45 × 100 = **− 24,4 %**.
- Écart du marché : (12,90 − 17,45) / 17,45 × 100 = − 4,55 / 17,45 × 100 = **− 26,1 %**.
- Si une famille achète ce panier chaque semaine à la supérette plutôt qu'au marché, elle dépense (17,45 − 12,90) × 52 = 4,55 × 52 = **236,60 €** de plus par an.

Lecture : le commerce le plus proche est le plus cher d'environ un quart. Pour les familles sans voiture, le supermarché (2,5 km) n'est pas une solution simple ; le marché l'est, s'il est accessible (jour, horaire, trajet). Le diagnostic croise ce résultat avec la marche exploratoire (partie 7.3.9).

Attention – Les limites d'un relevé de prix

Le relevé ne dit rien de la qualité gustative ni des quantités réellement achetées. Les promotions faussent la comparaison : on relève le prix habituel et l'on note la promotion à part. Un écart calculé une seule semaine reste un ordre de grandeur, que l'on présente avec la date du relevé.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.22

Dans une commune rurale, un panier de dix produits coûte 24,80 € à l'épicerie du village, 19,30 € au supermarché du bourg voisin (12 km) et 21,10 € au drive du même supermarché, livraison comprise. a) Calculez l'écart de chaque solution par rapport à l'épicerie. b) Une famille fait ses courses une fois par semaine : quel est l'écart annuel entre l'épicerie et le supermarché ? c) Quelle information manque pour conclure ?

Corrigé

a) Supermarché : (19,30 − 24,80) / 24,80 × 100 = **− 22,2 %** ; drive livré : (21,10 − 24,80) / 24,80 × 100 = **− 14,9 %**. b) (24,80 − 19,30) × 52 = 5,50 × 52 = **286,00 €** par an. c) Le coût et la possibilité du trajet : 24 km aller-retour en voiture coûtent du carburant, et une personne sans voiture ne peut pas y aller. Il faut aussi connaître les besoins du public (quantités, produits réellement achetés) et vérifier si le drive livre dans le village.

Repérer l'insécurité alimentaire dans un diagnostic

L'environnement alimentaire décrit l'offre ; l'**insécurité alimentaire** décrit la situation des ménages : ne pas avoir un accès sûr, en quantité et en qualité, à une alimentation suffisante. Sa définition et l'échelle de la FAO (FIES, huit questions) sont présentées au chapitre 2. Dans un diagnostic de terrain, on n'a souvent ni le temps ni l'accord pour poser huit questions sensibles. On peut alors utiliser un **repérage court** et orienter ensuite.

Définition – Un repérage en deux questions

Le **Hunger Vital Sign** (Hager et coll., *Pediatrics*, 2010) a été construit aux États-Unis à partir de l'échelle américaine de sécurité alimentaire. Il pose deux questions sur les 12 derniers mois : « Nous avons eu peur de manquer de nourriture avant d'avoir de l'argent pour en racheter » ; « La nourriture achetée n'a pas suffi et nous n'avions pas d'argent pour en racheter ». Une réponse « souvent vrai » ou « parfois vrai » à l'une des deux questions signale un **risque** d'insécurité alimentaire. La traduction française utilisée ici est libre : elle sert au repérage, pas à une estimation comparable aux enquêtes nationales.

Exemple – Calcul détaillé : repérage dans une permanence de PMI

Pendant deux semaines, 64 familles venues à la permanence (fictive) ont accepté de répondre aux deux questions. 23 familles répondent « souvent » ou « parfois » vrai à au moins une question, soit 23 / 64 × 100 = **35,9 %**. 31 familles déclarent par ailleurs avoir reçu une aide alimentaire au cours de l'année, soit **48,4 %**.

Lecture : plus d'une famille sur trois présente un risque d'insécurité alimentaire. Le recueil a eu lieu en PMI, auprès de familles venues consulter : on ne peut pas généraliser ce chiffre à toutes les familles de la commune. On l'écrit dans le dossier comme une **donnée locale de repérage**, à côté d'une donnée nationale sourcée et datée.

Attention – Poser des questions sensibles

Parler de faim ou de manque d'argent peut être humiliant. On explique pourquoi on pose la question, on garantit l'anonymat, on laisse la possibilité de ne pas répondre, et l'on prévoit **toujours** une orientation : la liste des aides alimentaires, de l'épicerie solidaire et du CCAS est remise à toutes les personnes, qu'elles répondent ou non, pour ne pas désigner celles qui sont en difficulté. Ces règles reprennent les principes éthiques du chapitre 6.

Lien diététique – Ce que le repérage change au projet

Un taux élevé d'insécurité alimentaire modifie les objectifs : un atelier qui conseille d'acheter des produits chers ou du matériel serait inadapté. Les recettes doivent rester à faible coût, utiliser les produits distribués par l'aide alimentaire, et le projet peut intégrer un partenariat avec les structures d'aide. Le coût des recettes se calcule avec les méthodes des chapitres 10 et 12.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.23

Dans un quartier, 120 ménages interrogés au porte-à-porte (tirage systématique dans la liste des logements) répondent aux deux questions de repérage ; 42 sont repérés à risque. a) Calculez la proportion de ménages à risque. b) Calculez la marge d'erreur à 95 % et l'intervalle de confiance. c) Rédigez la phrase du dossier.

Corrigé

a) 42 / 120 × 100 = **35,0 %**. b) e = 1,96 × √(0,35 × 0,65 / 120) = 1,96 × √(0,2275 / 120) = 1,96 × √0,001896 = 1,96 × 0,0435 = **0,085**, soit **± 8,5 points** ; intervalle : **26,5 % à 43,5 %**. c) « Selon un repérage en deux questions (Hunger Vital Sign, traduction libre), 35,0 % des 120 ménages interrogés présentaient un risque d'insécurité alimentaire au cours des 12 derniers mois (intervalle de confiance à 95 % : 26,5 % à 43,5 % ; ménages tirés au sort, données fictives). »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.10 – L'environnement alimentaire

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la différence entre un désert alimentaire et un marais alimentaire ?
2. 2 commerces favorables et 6 défavorables : calculez l'indice d'environnement favorable.
3. Citez trois règles pour construire un panier de référence.
4. Un panier coûte 20,00 € à la supérette et 15,50 € au marché : calculez l'écart en pourcentage.
5. Que mesure le repérage de l'insécurité alimentaire en deux questions ?
6. Quelle précaution prend-on toujours après des questions sur le manque de nourriture ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.10

1. Dans un désert alimentaire, l'accès aux produits frais et abordables est difficile ; dans un marais alimentaire, l'offre est abondante mais dominée par des produits peu favorables à la santé.
2. 2 / (2 + 6) × 100 = 25,0 sur 100.
3. Produits fixes et courants, formats et qualités identiques, mêmes jours de relevé, méthode et date écrites (trois suffisent).
4. (15,50 − 20,00) / 20,00 × 100 = − 22,5 %.
5. Un risque d'insécurité alimentaire au cours des 12 derniers mois (peur de manquer, nourriture insuffisante faute d'argent).
6. On remet à tous la liste des aides et des structures d'orientation, sans désigner les personnes en difficulté.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 7.3.11.
3 ou 4 sur 6	Je refais le calcul du panier de référence.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 7.3.10 et je refais les exercices d'application.

7.3.11 Croiser les données : tableaux à double entrée

Module · Référentiel et guide : voir 7.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 7.2.2)

Pour comparer des groupes (familles avec ou sans enfants, quartiers, âges), on construit des **tableaux croisés** et l'on calcule les pourcentages dans le bon sens.

Méthode pas à pas – Pourcentages en ligne ou en colonne ?

On calcule les pourcentages **dans le sens du groupe que l'on veut comparer**. Pour comparer la consommation de légumes secs selon que les familles fréquentent ou non l'épicerie solidaire, on calcule le pourcentage de consommateurs **au sein de chaque groupe** (pourcentages en ligne si les groupes sont en lignes). Les pourcentages calculés sur le total général ne permettent pas cette comparaison.

Exemple – Calcul détaillé : légumes secs et fréquentation de l'épicerie

Groupe	Légumes secs ≥ 2 fois/semaine	Moins souvent	Total
Familles inscrites à l'épicerie	9	21	30
Familles non inscrites	4	14	18
Total	13	35	48

- Pourcentages en ligne : inscrites : 9 / 30 × 100 = **30,0 %** ; non inscrites : 4 / 18 × 100 = **22,2 %** ; ensemble : 13 / 48 × 100 = **27,1 %**.
- Écart : 30,0 − 22,2 = **7,8 points** ; rapport : 30,0 / 22,2 = **1,35**.
- **Prudence** : avec 30 et 18 familles, un écart de 7,8 points peut être dû au hasard (les marges d'erreur de

chaque groupe dépassent 15 points) ; on le présente comme une **tendance** à vérifier, pas comme un résultat.

Le piège du facteur de confusion

Un tableau croisé montre une **association** entre deux variables, pas une cause. Une troisième variable peut être liée aux deux et créer une association trompeuse : c'est un **facteur de confusion**. La notion est développée au chapitre 16 ; dans un diagnostic, il suffit de savoir la repérer et de vérifier l'association **dans chaque groupe** de la troisième variable. On parle de **stratification**.

Exemple – Calcul détaillé : les ateliers passés et la consommation de fruits

Dans un centre social (fictif), 80 parents ont répondu. On compare la part de parents qui mangent un fruit chaque jour selon qu'ils ont participé ou non aux ateliers de l'an dernier.

- Participants : 13 sur 25, soit **52,0 %** ; non-participants : 17 sur 55, soit **30,9 %**. Rapport : 52,0 / 30,9 = **1,68**.

On serait tenté de conclure que les ateliers ont fait progresser la consommation de fruits. Mais les ateliers avaient lieu le mardi à 14 h : seuls les parents qui ne travaillent pas à temps plein pouvaient y venir. On sépare donc les deux groupes.

Groupe	Participants : fruit chaque jour	Non-participants : fruit chaque jour	Rapport
Parents sans emploi à temps plein (n = 40)	12 sur 20, soit 60,0 %	11 sur 20, soit 55,0 %	1,09
Parents à temps plein (n = 40)	1 sur 5, soit 20,0 %	6 sur 35, soit 17,1 %	1,17
Ensemble (n = 80)	13 sur 25, soit 52,0 %	17 sur 55, soit 30,9 %	1,68

Lecture : dans chaque groupe, l'écart entre participants et non-participants est faible (rapports de 1,09 et 1,17). La grande différence globale vient surtout du **temps disponible**, lié à la fois à la participation (horaire de l'atelier) et à la consommation de fruits (temps pour les courses et les repas). On ne peut pas attribuer la différence aux ateliers. Le diagnostic retient plutôt un fait important : l'horaire des ateliers exclut les parents qui travaillent.

Méthode pas à pas – Repérer un facteur de confusion possible

1. Se demander : « Qu'est-ce qui pourrait expliquer à la fois la variable A et la variable B ? » (âge, revenus, temps disponible, lieu de vie, niveau scolaire).

2. Séparer les répondants selon ce facteur et recalculer les pourcentages dans chaque groupe.

3. Comparer : si l'écart disparaît ou change beaucoup dans les groupes, le facteur joue un rôle de confusion.

4. Écrire prudemment : « association observée », « tendance », et jamais « les ateliers ont permis » à partir d'un simple tableau croisé.

Attention – Les petits groupes après stratification

Quand on sépare les répondants, chaque groupe devient petit (5 participants à temps plein dans l'exemple). Les pourcentages calculés sur moins de 20 personnes sont très imprécis : on donne les effectifs et l'on présente le résultat comme une piste, pas comme une preuve.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.24

Dans un collège (fictif), 69,1 % des élèves inscrits à la cantine (38 sur 55) prennent un petit-déjeuner chaque jour, contre 75,4 % des non-inscrits (49 sur 65). Une enseignante en conclut que « la cantine fait sauter le

petit-déjeuner ». On sépare les élèves selon que leurs parents partent travailler avant 7 h ou non :

- parents partis avant 7 h : inscrits 18 sur 30 ; non-inscrits 9 sur 15 ;
- parents présents le matin : inscrits 20 sur 25 ; non-inscrits 40 sur 50.

Calculez les pourcentages dans chaque groupe. La conclusion de l'enseignante est-elle justifiée ?

Corrigé

Parents partis avant 7 h : inscrits 18 / 30 = **60,0 %** ; non-inscrits 9 / 15 = **60,0 %** (rapport **1,00**). Parents présents : inscrits 20 / 25 = **80,0 %** ; non-inscrits 40 / 50 = **80,0 %** (rapport **1,00**). Dans chaque groupe, il n'y a aucune différence. L'écart global vient du fait que les élèves dont les parents partent tôt sont plus souvent inscrits à la cantine (30 sur 45 contre 25 sur 75) et prennent moins souvent un petit-déjeuner. La conclusion n'est pas justifiée : le facteur à retenir pour le diagnostic est l'organisation du matin dans les familles.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.11 – Croiser les données

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans quel sens calcule-t-on les pourcentages d'un tableau croisé ?
2. 12 sur 40 dans un groupe et 6 sur 30 dans l'autre : calculez les deux pourcentages, l'écart en points et le rapport.
3. Qu'est-ce qu'un facteur de confusion ?
4. Comment vérifie-t-on qu'une variable joue un rôle de confusion ?
5. Quelle formulation utilise-t-on pour une association observée dans un tableau croisé ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.11

1. Dans le sens du groupe que l'on veut comparer : au sein de chaque groupe.
2. 12 / 40 = 30,0 % ; 6 / 30 = 20,0 % ; écart de 10,0 points ; rapport 30,0 / 20,0 = 1,50.
3. Une troisième variable, liée aux deux variables étudiées, qui crée ou modifie une association entre elles.
4. On sépare les répondants selon cette variable (stratification) et l'on recalcule les pourcentages dans chaque groupe.
5. « Association observée » ou « tendance », jamais une relation de cause à effet affirmée.

Mon score	Ce que je fais
5 sur 5	Je passe à la partie 7.3.12.
3 ou 4 sur 5	Je refais l'exemple de stratification.
Moins de 3 sur 5	Je relis toute la partie 7.3.11 et je refais l'exercice d'application.

7.3.12 Formuler une problématique de projet

Module · Référentiel et guide : voir 7.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 7.2.2)

Dans un dossier de projet (et dans le dossier de l'épreuve E5), la **problématique** fait le lien entre le **diagnostic** et le **projet** : elle exprime, sous forme de question, l'enjeu auquel le projet répond, en tenant compte du public, du contexte et des leviers d'action.

Méthode pas à pas – Construire une problématique en 4 étapes

1. Partir du constat central du diagnostic (problème central et ses causes principales).

2. Identifier la tension ou le paradoxe : ce qui rend la situation difficile (« les familles souhaitent mieux

manger mais pensent que c'est trop cher », « l'offre existe mais n'est pas utilisée »).

3. Préciser le public, le lieu et le levier sur lequel le projet peut agir.

4. Formuler une question ouverte, à laquelle le projet apporte une réponse argumentée (« Comment… ? », « En quoi… ? »), sans réponse par oui ou par non.

Formulation insuffisante	Formulation améliorée
« Les familles mangent-elles mal ? » (question fermée, jugeante)	« Comment aider les familles du quartier des Tilleuls, qui associent alimentation équilibrée et coût élevé, à intégrer davantage de légumes et de légumes secs à leurs repas avec leur budget ? »
« Comment lutter contre l'obésité ? » (trop vaste, centrée sur le poids)	« En quoi des ateliers culinaires participatifs, associés à un partenariat avec l'épicerie solidaire, peuvent-ils améliorer la diversité de l'alimentation des familles d'un quartier prioritaire ? »
« Pourquoi faire des ateliers cuisine ? » (part de la solution)	« Comment développer les compétences culinaires des parents pour réduire la place des produits transformés dans les goûters des enfants ? »

Attention – Problématique, problème central, objectif général

Le **problème central** décrit une situation (« l'alimentation des familles est peu diversifiée ») ; la **problématique** pose la question à laquelle le projet répond (« comment… ? ») ; l'**objectif général** énonce le but auquel le projet contribue (« contribuer à améliorer… »). Les trois doivent être **cohérents** entre eux : le jury vérifie ce fil logique.

Vérifier la chaîne logique du diagnostic aux objectifs

Le jury lit un dossier comme une chaîne : chaque maillon doit découler du précédent. Un objectif qui ne répond à aucune cause, ou un indicateur qui ne mesure pas l'objectif, casse la chaîne. Avant de rendre un dossier, on remplit un **tableau de cohérence** qui aligne, sur une même ligne, le constat, la cause, l'objectif et l'indicateur.

Constat du diagnostic (source)	Cause retenue	Objectif spécifique	Indicateur et valeur initiale
73 % des familles mangent des légumes secs moins de 2 fois par semaine (questionnaire, n = 48)	Compétences culinaires insuffisantes	Au moins 60 % des familles participantes consomment des légumes secs 2 fois par semaine d'ici fin mai	Part des familles « 2 fois ou plus » ; 25 % au premier atelier
34 parents sur 48 pensent que manger équilibré coûte cher	Représentation sur le coût	Au moins 75 % des participants citent 3 aliments favorables à moins de 2 € le kilo à la fin du cycle	Score au questionnaire ; 4 participants sur 12 au départ
22 enfants sur 48 boivent une boisson sucrée chaque jour au goûter	Habitudes de goûter des familles	La part des familles qui proposent une boisson sucrée au goûter passe de 46 % à 23 % au plus	Questionnaire de fréquence ; 46 %

Méthode pas à pas – Quatre contrôles de cohérence

1. Lire chaque ligne de gauche à droite : la cause explique-t-elle le constat ? L'objectif agit-il sur la cause ? L'indicateur mesure-t-il l'objectif ?

2. Vérifier les publics : le constat, l'objectif et l'indicateur portent-ils sur le même public (familles du quartier, ou seulement familles participantes) ?

3. Vérifier les chiffres : la valeur initiale de l'indicateur correspond-elle au constat ou à une mesure faite au premier atelier, et est-ce dit ?

4. Vérifier les manques : chaque cause retenue a-t-elle au moins un objectif ? Chaque objectif opérationnel sert-il un objectif spécifique ?

Exemple – Une chaîne cassée et sa réparation

Dossier d'une stagiaire en EHPAD (fictif). Constat : « 18 résidents sur 62 ont perdu plus de 5 % de leur poids en un mois. » Cause retenue : « Les collations de l'après-midi sont peu consommées. » Objectif spécifique : « Former 10 soignants aux repères nutritionnels de la personne âgée. » Indicateur : « Nombre de soignants formés. »

Problèmes : l'objectif porte sur l'équipe (c'est un objectif **opérationnel**) et l'indicateur est un indicateur de **processus**. Aucun objectif ne vise un changement chez les résidents.

Réparation : objectif spécifique : « D'ici trois mois, au moins 70 % des résidents concernés consomment au moins la moitié de leur collation enrichie (observation sur 5 jours) » ; objectif opérationnel : « Former 10 soignants à la présentation et à l'aide à la prise des collations d'ici un mois. » La formation sert désormais un objectif centré sur les résidents.

Astuce – Le test des questions « comment ? » et « pourquoi ? »

En lisant le tableau de cohérence de haut en bas, on demande « comment ? » : comment atteindre l'objectif général ? Par les objectifs spécifiques. En lisant de bas en haut, on demande « pourquoi ? » : pourquoi animer ces ateliers ? Pour atteindre tel objectif spécifique. Si une réponse manque, il manque un maillon (figure 7.7).

À vous de jouer – Exercice d'application 7.25

Repérez l'incohérence de chaque ligne et proposez une correction. a) Constat : 40 % des lycéens de l'internat sautent le petit-déjeuner. Objectif spécifique : « Les lycéens connaîtront les repères du PNNS. » b) Constat : les familles trouvent le marché trop éloigné. Objectif spécifique : « 80 % des familles cuisineront des légumes de saison. » c) Objectif spécifique : « D'ici juin, 60 % des enfants goûteront un légume nouveau à la cantine. » Indicateur : « Nombre d'animations réalisées. »

Corrigé

a) L'objectif porte sur des connaissances générales, alors que le constat porte sur un comportement précis : « D'ici juin, la part des internes qui prennent un petit-déjeuner au moins 5 jours sur 7 passe de 60 % à 80 % (questionnaire). » b) L'objectif ne répond pas à la cause (l'accès) : « D'ici six mois, au moins 50 % des familles utilisent une solution d'accès aux produits frais (navette, panier livré, marché) au moins une fois par mois. » c) L'indicateur mesure ce que fait l'équipe, pas le changement visé : « Part des enfants qui goûtent le légume nouveau (grille d'observation à la cantine). »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.12 – La problématique et la chaîne logique

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre étapes de construction d'une problématique.
2. Pourquoi « Les familles mangent-elles mal ? » n'est-elle pas une bonne problématique ?
3. Distinguez problème central, problématique et objectif général.
4. Quelles sont les quatre colonnes d'un tableau de cohérence ?
5. « Former 10 soignants » : est-ce un objectif spécifique ou opérationnel ? Pourquoi ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.12

1. Partir du constat, identifier la tension, préciser le public, le lieu et le levier, formuler une question ouverte.
2. C'est une question fermée (réponse oui ou non) et jugeante.
3. Le problème central décrit une situation ; la problématique pose la question à laquelle le projet répond ; l'objectif général énonce le but auquel le projet contribue.
4. Constat (avec sa source), cause retenue, objectif spécifique, indicateur et valeur initiale.
5. Opérationnel : il décrit ce que réalise l'équipe, pas un changement chez le public.

Mon score	Ce que je fais
5 sur 5	Je passe à la partie 7.3.13.
3 ou 4 sur 5	Je refais le tableau de cohérence de l'exemple.
Moins de 3 sur 5	Je relis toute la partie 7.3.12 et je refais l'exercice d'application.

7.3.13 Du diagnostic à la stratégie : la matrice FFOM croisée

Module · Référentiel : C3.1 · CNED : Essentiels M1 S2 §3 (p. 12)

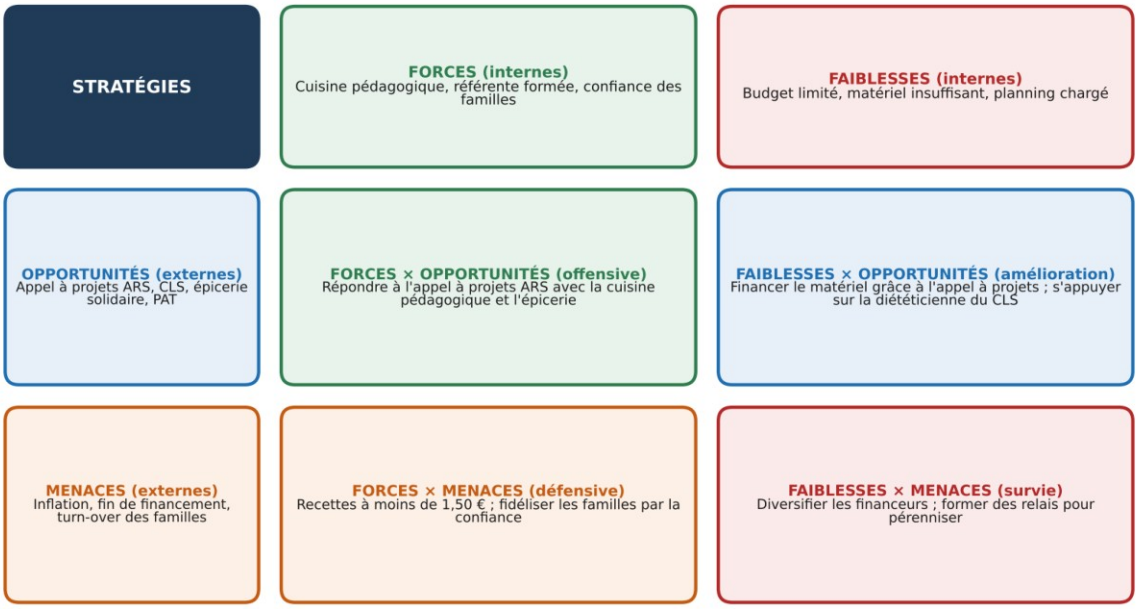


Figure 7.14 – La matrice FFOM croisée du centre social des Tilleuls

Comprendre le schéma – Figure 7.14

1. La matrice **croisée** (appelée aussi TOWS) transforme l'analyse FFOM (7.3.5) en **stratégies**.

2. **Forces × opportunités** (stratégie offensive) : utiliser ses atouts pour saisir les occasions (la cuisine pédagogique et le partenariat avec l'épicerie pour répondre à l'appel à projets).

3. **Faiblesses × opportunités** (stratégie d'amélioration) : profiter des opportunités pour corriger les faiblesses (financer le matériel).

4. **Forces × menaces** (stratégie défensive) : utiliser ses atouts pour réduire les menaces (recettes très économiques face à l'inflation).

5. **Faiblesses × menaces** (stratégie de survie) : réduire la vulnérabilité (diversifier les financeurs, former des relais).

6. Ces stratégies préparent le **plan d'action** (chapitre 8).

Remplir une matrice FFOM croisée pas à pas

La matrice croisée (figure 7.14) se remplit en deux temps. D'abord, on liste trois à cinq éléments dans chacune des quatre cases de l'analyse FFOM, chacun appuyé par un fait. Ensuite, on croise les cases deux à deux et l'on écrit, pour chaque croisement, une ou deux stratégies concrètes.

Méthode pas à pas – Du FFOM à la stratégie

1. Lister les forces et faiblesses (internes) et les opportunités et menaces (externes), en phrases courtes et précises : « cuisine pédagogique équipée de 6 postes » plutôt que « bons locaux ».

2. Croiser : pour chaque paire (force et opportunité, faiblesse et opportunité, force et menace, faiblesse et menace), se demander « que pouvons-nous faire ? ».

3. Trier les stratégies : retenir celles qui répondent aux priorités du diagnostic et qui sont faisables.

4. Transférer les stratégies retenues dans le plan d'action (chapitre 8).

Exemple – Une association d'aide à domicile prépare un projet

Une association d'aide à domicile (fictive) veut prévenir la dénutrition des personnes âgées qu'elle accompagne.

- **Forces** : 42 auxiliaires de vie qui voient les personnes chaque semaine ; une infirmière coordinatrice ; un logiciel de suivi des interventions.
- **Faiblesses** : aucune formation des auxiliaires sur la nutrition depuis 2019 ; pas de balance au domicile ; temps d'intervention court (30 minutes).
- **Opportunités** : appel à projets de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie ; diététicienne libérale prête à intervenir ; action régionale sur la dénutrition.
- **Menaces** : difficultés de recrutement ; hausse du prix des produits alimentaires ; refus de certaines personnes d'être pesées.

Croisement	Stratégie proposée
Forces × opportunités (offensive)	Répondre à l'appel à projets en s'appuyant sur les visites hebdomadaires pour repérer la perte d'appétit avec une grille simple
Faiblesses × opportunités (amélioration)	Financer par l'appel à projets une formation de deux demi-journées des auxiliaires par la diététicienne, et l'achat de balances
Forces × menaces (défensive)	Utiliser le logiciel pour signaler rapidement à l'infirmière un repas non consommé, sans peser les personnes qui refusent
Faiblesses × menaces (survie)	Former deux auxiliaires référentes qui transmettront la grille aux nouvelles recrues, pour ne pas perdre les acquis à chaque départ

Lecture : chaque stratégie part d'un élément précis de la matrice. La stratégie défensive respecte le refus de la pesée (principe d'autonomie, chapitre 6) tout en gardant un repérage par l'observation des repas.

Attention – Erreurs fréquentes dans une FFOM

Placer une caractéristique du public en « faiblesse » (« les personnes âgées sont isolées ») : c'est un élément du diagnostic de la population, pas une faiblesse de la structure. Placer une action future en « opportunité » (« faire des ateliers ») : une opportunité existe déjà à l'extérieur. Écrire des éléments vagues (« bonne équipe

») : on ne peut rien en tirer.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.26

Un club de football amateur (fictif) veut améliorer les goûters de ses 120 jeunes licenciés. Forces : 8 éducateurs bénévoles motivés ; une buvette gérée par des parents. Faiblesses : aucun éducateur formé à la nutrition ; la buvette vend surtout des barres chocolatées et des sodas, qui financent une partie des déplacements. Opportunités : la commune soutient les projets « sport-santé » ; un supermarché voisin propose des partenariats locaux. Menaces : les parents craignent une hausse de la cotisation ; la concurrence des distributeurs automatiques du gymnase. Rédigez une stratégie pour chacun des quatre croisements.

Corrigé

Offensive : s'appuyer sur les éducateurs et la buvette pour déposer un projet « sport-santé » à la commune (goûters de fruits et eau après l'entraînement). Amélioration : utiliser la subvention ou le partenariat du supermarché pour former deux éducateurs et proposer à la buvette des produits favorables vendus à un prix qui préserve son bénéfice. Défensive : faire préparer et vendre par les parents de la buvette des goûters attractifs et peu chers (compote, fruit, pain), plus intéressants que les distributeurs. Survie : remplacer progressivement les sodas par de l'eau aromatisée maison pour ne pas perdre d'un coup le financement des déplacements, et présenter le projet aux parents sans hausse de cotisation.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.13 – La matrice FFOM croisée

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quels éléments de la FFOM sont internes, lesquels sont externes ?
2. Nommez les quatre stratégies de la matrice croisée et le croisement qui correspond à chacune.
3. « Les habitants du quartier ont peu de revenus » : est-ce une faiblesse de la structure ? Justifiez.
4. « Proposer des ateliers cuisine » : est-ce une opportunité ? Justifiez.
5. Où les stratégies retenues sont-elles reprises ensuite ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.13

1. Internes : forces et faiblesses ; externes : opportunités et menaces.
2. Offensive (forces × opportunités), amélioration (faiblesses × opportunités), défensive (forces × menaces), survie (faiblesses × menaces).
3. Non : c'est une caractéristique du public, qui appartient au diagnostic de la population.
4. Non : c'est une action future ; une opportunité existe déjà dans l'environnement extérieur.
5. Dans le plan d'action (chapitre 8).

Mon score	Ce que je fais
5 sur 5	Je passe à la partie 7.3.14.
3 ou 4 sur 5	Je refais l'exemple de l'association d'aide à domicile.
Moins de 3 sur 5	Je relis toute la partie 7.3.13 et je refais l'exercice d'application.

7.3.14 Fil rouge : le diagnostic d'Inès pas à pas

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 7.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le calendrier du diagnostic (période 1 de stage, 31 mai – 11 juin 2027)

Jour	Activités
J1-J2	Découverte du centre social, entretien avec la tutrice (missions, public, contraintes) ; lecture du projet social et du rapport d'activité ; recherche des données Insee et du contrat de ville
J3	Repérage à pied de l'offre alimentaire du quartier (grille d'observation) ; relevé de prix de 15 produits à la supérette et au marché
J4	Entretiens semi-directifs : animatrice familles, responsable de l'épicerie solidaire, puéricultrice de PMI (grille de 8 questions, 30 minutes chacun)
J5	Construction du questionnaire (14 questions), prétest auprès de 4 mamans, corrections
J6-J7	Passation à la sortie des 2 écoles et à l'épicerie (48 questionnaires, dont 11 en lecture orale et 6 avec médiatrice)
J8	Groupe de parole (8 parents, 1 h 15) : « Bien manger avec un petit budget, qu'est-ce qui est difficile ? »
J9	Saisie dans le tableur, calculs, graphiques ; analyse thématique du groupe de parole
J10	Arbre à problèmes avec la tutrice et la diététicienne ; priorisation (Hanlon) ; restitution orale à l'équipe

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le relevé de prix (extrait) et ce qu'il démontre

Produit	Supérette (€/kg)	Marché (€/kg)	Écart
Carottes	2,10	1,40	− 33,3 %
Pommes	3,20	2,40	− 25,0 %
Lentilles vertes sèches	4,80	3,60 (vrac)	− 25,0 %
Pommes de terre	1,90	1,30	− 31,6 %

Calcul de l'écart = (prix marché − prix supérette) / prix supérette × 100. Carottes : (1,40 − 2,10) / 2,10 × 100 = − 0,70 / 2,10 × 100 = **− 33,3 %** ; pommes de terre : (1,30 − 1,90) / 1,90 × 100 = − 0,60 / 1,90 × 100 = **− 31,6 %**. **Coût d'une portion de lentilles** (60 g crus) : 0,060 × 3,60 = **0,22 €** au marché, contre 0,060 × 4,80 = **0,29 €** à la supérette ; une portion de steak haché (100 g à 11,00 €/kg) coûte 1,10 €. **Conclusion** : les légumes secs sont parmi les sources de protéines les moins chères, ce qui contredit la représentation « équilibré = cher » et justifie l'atelier n° 1 ; mais le marché est à 2,5 km : d'où la **visite accompagnée** du marché.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le groupe de parole : analyse thématique

Thème	Parents (n = 8)	Verbatim représentatif
Coût des fruits et légumes	7	« Les légumes, c'est ce qui coûte le plus, alors j'achète des pâtes. »
Manque de temps et de fatigue	6	« Le soir, je n'ai pas le courage de cuisiner. »
Refus des enfants	6	« Il ne mange que des frites et des nuggets. »
Méconnaissance des légumes secs	5	« Les lentilles, je ne sais pas les faire, ma mère les faisait. »
Envie de cuisiner ensemble	5	« Ce serait bien de cuisiner à plusieurs, et de discuter. »

Le thème « envie de cuisiner ensemble » (5 parents sur 8, soit 62,5 %) confirme le **besoin exprimé** et oriente vers une méthode **collective et conviviale**.

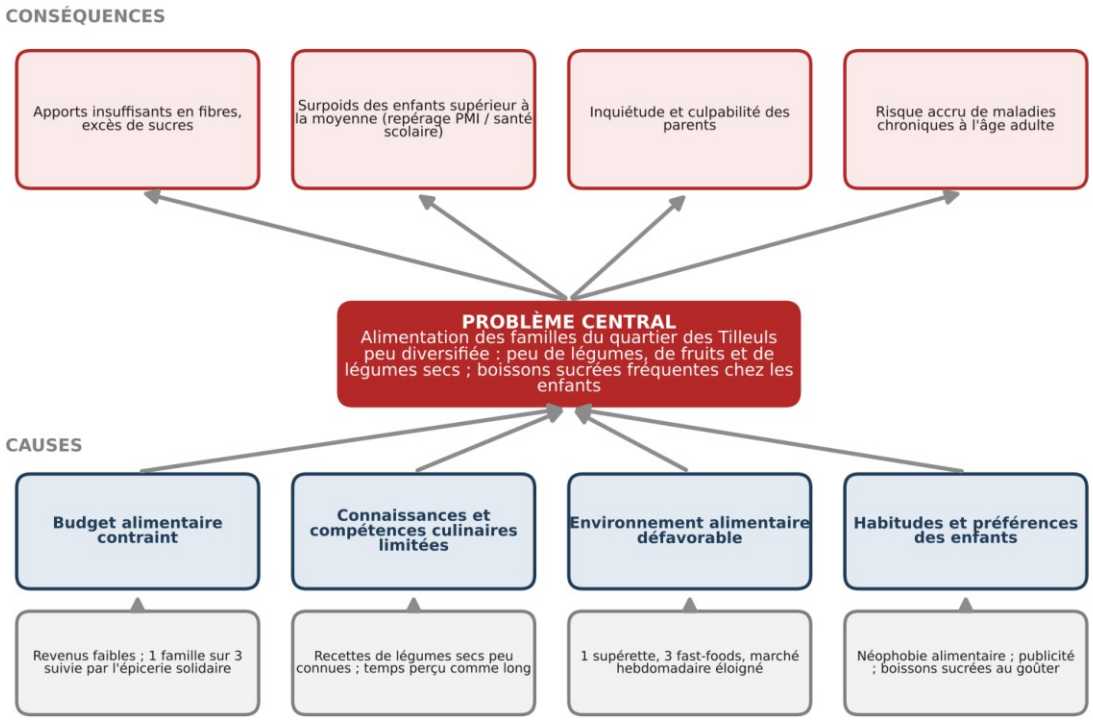


Figure 7.8 – L'arbre à problèmes du projet fil rouge (rappel du chapitre 1)

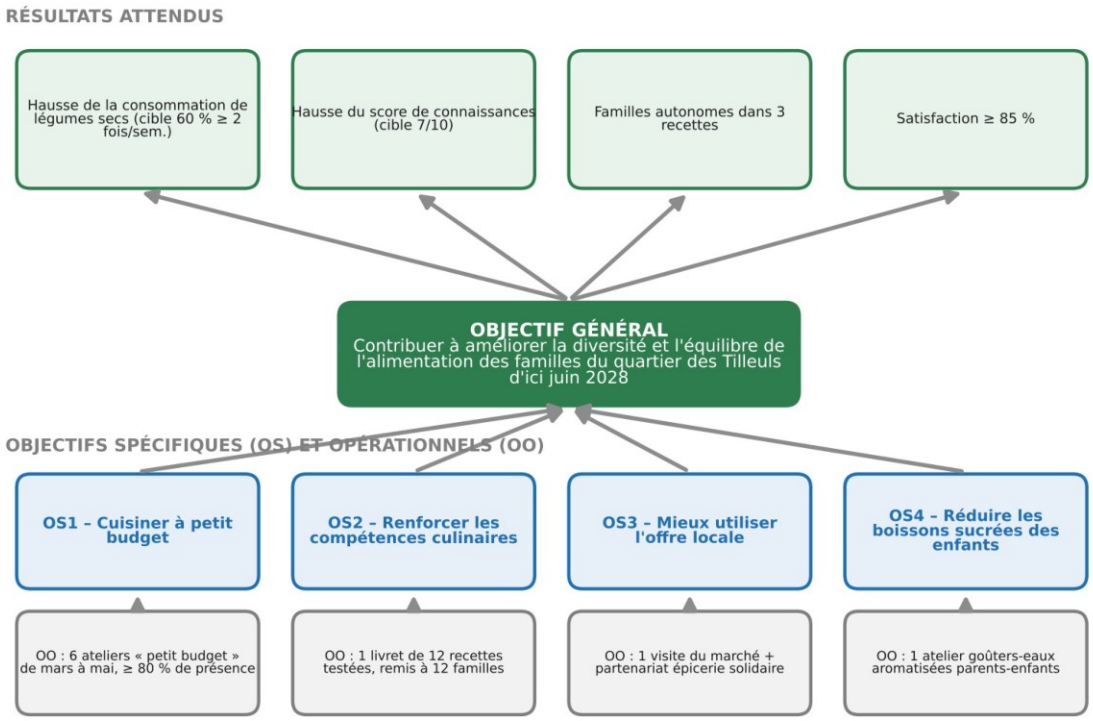


Figure 7.9 – L'arbre à objectifs du projet fil rouge (rappel du chapitre 1)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les choix d'Inès et leur justification

- **Causes retenues** : compétences culinaires (légumes secs, légumes), représentations sur le coût, habitudes

des enfants (goûters, boissons), accès à l'offre à petit prix (partenariat avec l'épicerie, visite du marché).

- **Causes non retenues** et pourquoi : revenus des familles (hors champ du centre social → plaidoyer auprès du CCAS et de la commune) ; offre commerciale du quartier (relève du PAT et de la commune → information transmise au comité du CLS) ; sédentarité (pas de moyens → orientation vers le club sportif municipal).
- **Hiérarchie** : 1 objectif général, 4 objectifs spécifiques, 2 objectifs opérationnels principaux (fiche F3, chapitre 1) ; chaque objectif spécifique a un **indicateur** et une **valeur initiale** mesurée au 1er atelier.

7.3.15 Rédiger la partie « analyse de situation et diagnostic » d'un dossier

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 7.2.2)

Méthode pas à pas – Plan conseillé (3 à 5 pages)

1. Présentation de la structure : statut, missions, public, moyens, place dans le territoire (½ page).

2. Contexte : territoire et population (2 à 4 chiffres sourcés), état de santé et comportements (données nationales puis locales), politiques de santé dans lesquelles s'inscrit le projet (1 page).

3. Méthode du diagnostic : outils utilisés (questionnaire, entretiens, observation), dates, nombre de personnes, conditions de passation, limites (½ page).

4. Résultats : besoins normatifs, ressentis, exprimés, comparatifs ; tableaux et graphiques légendés et interprétés (1 à 2 pages).

5. Synthèse : problème central, arbre à problèmes, priorisation argumentée, causes retenues et non retenues (1 page).

6. Objectifs : général, spécifiques, opérationnels, avec indicateurs (½ page) ; les outils détaillés (questionnaire, grilles) vont en **annexe**.

Astuce – Formulations utiles (à adapter à votre propre projet)

- « Pour analyser la situation, j'ai croisé trois sources : … »
- « Ce résultat doit être interprété avec prudence, car … (taille de l'échantillon, lieu de passation). »
- « Le besoin est à la fois normatif (…), ressenti (…) et exprimé (…), ce qui justifie … »
- « Parmi les causes identifiées, le projet agit sur … ; en revanche, … relève de … »
- « J'ai retenu ce problème selon quatre critères : ampleur, gravité, efficacité des actions possibles et faisabilité. »

Auto-vérification de la partie diagnostic	Oui	Non	À revoir
Chaque chiffre a une source et une date	[ ]	[ ]	[ ]
Les données nationales, locales et recueillies sont distinguées	[ ]	[ ]	[ ]
La méthode de recueil et ses limites sont décrites	[ ]	[ ]	[ ]
Les pourcentages sont accompagnés des effectifs (n)	[ ]	[ ]	[ ]
Les graphiques ont un titre, une source, une interprétation	[ ]	[ ]	[ ]
Le problème central est une situation négative observable	[ ]	[ ]	[ ]
Chaque cause de l'arbre repose sur un fait	[ ]	[ ]	[ ]
Les priorités sont justifiées par des critères explicites	[ ]	[ ]	[ ]
Les objectifs spécifiques portent sur le public et sont SMART	[ ]	[ ]	[ ]
Les objectifs opérationnels décrivent ce que fait l'équipe	[ ]	[ ]	[ ]

Fil rouge – centre social des tilleuls – Compléments : la problématique et la stratégie d'Inès

- **Groupe nominal** : lors du groupe de parole (8 parents), Inès a utilisé la technique du groupe nominal ; le coût des fruits et légumes est arrivé en tête (31 points sur 120), suivi du refus des légumes par les enfants (26) et de la méconnaissance des légumes secs (22).
- **Environnement alimentaire** : indice d'environnement favorable de 28,6 / 100 dans un rayon de 800 m ; le quartier présente les caractéristiques d'un marais alimentaire.
- **Problématique retenue** : « Comment aider les familles du quartier des Tilleuls, qui associent alimentation équilibrée et coût élevé, à intégrer davantage de légumes et de légumes secs à leurs repas, avec leur budget et leurs habitudes culturelles ? »
- **Cohérence** : problème central (alimentation peu diversifiée) → problématique (comment… avec leur budget ?) → objectif général (contribuer à améliorer la diversité et l'équilibre de l'alimentation des familles) → objectifs spécifiques (légumes secs, connaissances petit budget, offre locale, boissons du goûter).
- **Stratégie** (matrice FFOM croisée) : offensive (appel à projets ARS + cuisine pédagogique + épicerie) ; amélioration (achat d'une balance et d'ustensiles grâce à la subvention) ; défensive (recettes à moins de 1,50 €) ; survie (formation de deux mamans relais pour pérenniser).

7.4 Approfondissements

7.4.1 Le diagnostic local de santé et le contrat local de santé

Les **contrats locaux de santé** (CLS), prévus par l'article L. 1434-10 du Code de la santé publique, sont signés entre l'ARS et une collectivité (commune, intercommunalité) pour mettre en œuvre le projet régional de santé sur un territoire. Ils s'appuient sur un **diagnostic local de santé**, souvent réalisé par l'observatoire régional de la santé (ORS), qui combine indicateurs statistiques et consultation des habitants et des professionnels. Pour un étudiant, ce diagnostic est une **source précieuse** : il donne des données locales récentes et indique les priorités (fiches-actions) que le projet peut rejoindre, ce qui facilite son financement (chapitre 8).

Lire un diagnostic local de santé en stage

Quand un diagnostic local de santé existe, il fait gagner beaucoup de temps : il rassemble des indicateurs, l'avis des professionnels et souvent celui des habitants. Il faut cependant savoir le lire et l'utiliser sans le recopier.

Méthode pas à pas – Exploiter un diagnostic local en quatre lectures

1. Lire la méthode : qui l'a réalisé (ORS, cabinet, collectivité), en quelle année, avec quelles sources et quelles consultations. Un diagnostic de plus de cinq ans se complète par des données récentes.

2. Lire la synthèse : les priorités retenues et les axes du contrat local de santé. On repère si l'alimentation, l'activité physique ou les maladies chroniques y figurent.

3. Lire les indicateurs utiles au projet, et seulement ceux-là ; on note la page et l'année de chaque chiffre.

4. Lire les fiches-actions : elles disent qui porte quoi, avec quel budget, et elles montrent où un projet de stage peut s'insérer.

Exemple – Insérer un projet de stage dans un contrat local de santé

Le contrat local de santé d'une intercommunalité (fictif) comporte un axe « Bien manger et bouger à tous les âges » et une fiche-action « Développer les ateliers culinaires dans les structures de proximité », portée par le centre social et financée en partie par l'ARS. Le diagnostic local, réalisé en 2023, indique que les habitants du quartier prioritaire déclarent moins souvent consommer des fruits et des légumes chaque jour que le reste de l'intercommunalité. Le stagiaire peut : citer l'axe et la fiche-action pour montrer la cohérence de son projet ;

utiliser les indicateurs comme données de contexte (avec la page et l'année) ; compléter par un recueil de terrain sur son public précis, que le diagnostic local ne décrit pas ; transmettre ses résultats au coordinateur du CLS.

Attention – Recopier n'est pas diagnostiquer

Un diagnostic local décrit un territoire entier, pas le public d'une structure. Recopier ses conclusions dans un dossier de stage, sans recueil propre, ne montre aucune compétence de diagnostic. Le jury attend que l'étudiant utilise ce document comme **contexte**, puis qu'il apporte des données sur **son** public.

Lien diététique – Rencontrer le coordinateur du CLS

Le coordinateur ou la coordinatrice du contrat local de santé connaît les acteurs, les financements et les projets en cours. Un entretien de 30 minutes en début de stage évite de proposer une action qui existe déjà, et il peut ouvrir un partenariat ou un financement pour la suite du projet.

7.4.2 La participation des habitants au diagnostic

Le diagnostic **partagé** associe les habitants à toutes les étapes : choix des questions, recueil (habitants enquêteurs), interprétation (restitution collective où l'on valide ou corrige l'arbre à problèmes). Des méthodes participatives existent : **photo-expression** et **photovoice** (les habitants photographient ce qui, dans leur quartier, aide ou empêche de bien manger, puis commentent les photos), **marche exploratoire** dans le quartier, **cartographie participative** des lieux d'achat, **world café**. Elles renforcent l'**appropriation** du projet et le pouvoir d'agir (chapitre 3).

7.4.3 S'appuyer sur les données probantes

Avant de choisir une action, on vérifie ce qui a fait ses preuves : le **portail des interventions probantes ou prometteuses** de Santé publique France recense des programmes évalués (alimentation, activité physique, compétences psychosociales) avec leurs conditions de transfert. Le **transfert** d'une action d'un contexte à un autre suppose d'identifier ses **fonctions clés** (ce qui la rend efficace) et de les adapter au public (littératie, culture, budget).

Chercher une action probante et juger si elle est transférable

Une action qui a marché ailleurs ne marchera pas forcément chez soi. Avant de la reprendre, on vérifie deux choses : son **efficacité** (a-t-elle été évaluée, et avec quels résultats ?) et sa **transférabilité** (les conditions de son succès existent-elles dans notre contexte ?). La lecture critique d'une évaluation est présentée au chapitre 19, et l'outil d'analyse de transférabilité ASTAIRE au chapitre 9.

Méthode pas à pas – Utiliser le portail des interventions probantes

1. Chercher avec des mots du diagnostic : public (enfants, personnes âgées), milieu (école, quartier), thème (alimentation, activité physique).

2. Lire le niveau de preuve : intervention « probante » (efficacité démontrée par des évaluations solides) ou « prometteuse » (résultats encourageants, preuves encore limitées).

3. Repérer les fonctions clés : ce qui fait l'efficacité de l'action (par exemple, l'exposition répétée aux légumes, l'implication des parents, la durée).

4. Comparer les contextes : public, moyens, partenaires, durée, compétences de l'équipe.

5. Décider : reprendre tel quel, adapter la forme en gardant les fonctions clés, ou renoncer.

Critère de transférabilité	Question à se poser	Exemple de réponse
Public	Notre public ressemble-t-il à celui de l'action évaluée (âge, revenus, langue, littératie) ?	Action évaluée chez des enfants de 8 à 10 ans ; notre public a 6 à 11 ans : proche
Environnement	Les conditions extérieures sont-elles comparables (offre alimentaire, transports, politiques) ?	Action menée avec un marché sur place ; pas de marché chez nous : à adapter
Intervenants	Avons-nous les compétences et le temps des intervenants de l'action d'origine ?	Elle prévoyait une diététicienne 2 jours par semaine ; nous avons 4 heures : à réduire ou à financer
Durée et intensité	Pouvons-nous tenir la même durée et le même nombre de séances ?	12 séances sur un an ; nous en prévoyons 6 : risque d'effet plus faible
Partenariats	Les partenaires indispensables existent-ils ?	École et municipalité partenaires : oui

Exemple – Garder la fonction clé, changer la forme

Une action prometteuse (décrite pour l'exemple) propose aux enfants de goûter un légume différent chaque semaine pendant huit semaines, avec un carnet à colorier. La fonction clé est l'**exposition répétée** : goûter plusieurs fois le même aliment augmente son acceptation (chapitre 4). Dans un accueil de loisirs ouvert seulement le mercredi, on garde l'exposition répétée (huit mercredis de suite, trois goûts de chaque légume) mais l'on remplace le carnet par un jeu collectif, mieux adapté au fonctionnement du centre. Supprimer la répétition pour proposer une seule grande dégustation ferait perdre la fonction clé.

Attention – Citer une action sans la vérifier

Écrire dans un dossier « ce type d'action a fait ses preuves » sans référence est une affirmation gratuite. On cite le programme, la source (portail, rapport d'évaluation) et l'année de consultation. Si l'on ne trouve pas d'évaluation, on l'écrit honnêtement et l'on prévoit une évaluation rigoureuse de son propre projet.

7.4.4 Le diagnostic en milieu scolaire, en entreprise et en établissement

Le diagnostic s'adapte au **milieu** : en **milieu scolaire**, il associe l'infirmière, le médecin scolaire, le chef d'établissement, le gestionnaire de la restauration, les élèves (comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, CESCE) et s'appuie sur les bilans de santé et les pesées des restes ; en **entreprise**, il associe la direction, les représentants du personnel, le service de prévention et de santé au travail et le prestataire de restauration, en garantissant l'anonymat des salariés ; en **établissement médico-social**, il associe le conseil de la vie sociale (chapitre 6), l'équipe soignante, la cuisine et s'appuie sur les données de dénutrition et de satisfaction. Dans tous les cas, on identifie les **instances de décision** à mobiliser dès le diagnostic.

Adapter le diagnostic à chaque milieu : un tableau de repères

La démarche reste la même partout, mais les partenaires, les sources et les précautions changent d'un milieu à l'autre. Le tableau suivant sert de liste de contrôle au début d'un stage.

Milieu	Partenaires à rencontrer	Sources et outils utiles	Précaution principale
École, collège, lycée	Chef d'établissement, infirmière, gestionnaire de la restauration, élèves élus, parents	Bilans de santé (données agrégées), menus, pesée des restes, questionnaire élèves	Accord du chef d'établissement ; information des parents ; questions adaptées à l'âge
Entreprise	Direction, représentants du personnel, service de prévention et de santé au travail, prestataire de restauration	Questionnaire anonyme, horaires de travail, offre de restauration et de distributeurs	Anonymat strict : aucune donnée ne doit permettre d'identifier un salarié

Milieu	Partenaires à rencontrer	Sources et outils utiles	Précaution principale
Établissement pour personnes âgées	Direction, médecin coordonnateur, infirmière, cuisine, conseil de la vie sociale, familles	Courbes de poids (données agrégées), observation des repas, plans alimentaires, commission des menus	Consentement des résidents ; données de santé couvertes par le secret
Quartier, commune	Centre social, CCAS, élus, associations, habitants, PMI	Insee, contrat de ville, CLS, repérage de l'offre, marche exploratoire	Ne pas stigmatiser le quartier ; restituer aux habitants
Territoire rural	Intercommunalité, maisons France services, MSA, associations, producteurs	Distances et transports, PAT, relevé des points de vente	Prendre en compte les distances pour les passations ; diversifier les lieux
Structure d'aide alimentaire	Responsable, bénévoles, travailleurs sociaux, bénéficiaires	Composition des colis, fréquentation, entretiens	Respect de la dignité ; ne jamais conditionner l'aide à la participation

Lien diététique – Données agrégées et données individuelles

Dans un établissement, la stagiaire peut avoir accès à des dossiers de soins. Pour le diagnostic, elle n'utilise que des données **agrégées** (« 18 résidents sur 62 ont perdu plus de 5 % de leur poids en un mois »), transmises ou validées par un professionnel de l'établissement. Elle ne recopie jamais de données individuelles dans son dossier de stage. Les règles du secret professionnel et du RGPD sont détaillées aux chapitres 6 et 20.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.27

Vous commencez un stage dans une entreprise de 230 salariés qui travaillent en horaires postés (6 h–14 h, 14 h–22 h, 22 h–6 h). La direction souhaite « améliorer l'alimentation des équipes de nuit ». Citez quatre partenaires à rencontrer, trois sources ou outils de recueil, et deux précautions propres à ce milieu.

Corrigé

Partenaires : la direction des ressources humaines, les représentants du personnel, le service de prévention et de santé au travail, le prestataire de restauration ou le gestionnaire des distributeurs, des salariés volontaires de chaque équipe. Sources et outils : questionnaire anonyme distribué dans les trois équipes, relevé de l'offre disponible la nuit (distributeurs, salle de pause, micro-ondes), entretiens avec l'infirmière de santé au travail, observation des pauses. Précautions : garantir l'anonymat (aucune question permettant d'identifier une personne dans une petite équipe) ; organiser des passations aux horaires de nuit, pour ne pas recueillir seulement l'avis des équipes de jour.

7.4.5 Mesurer les inégalités dans le diagnostic

Un diagnostic attentif aux inégalités (universalisme proportionné, chapitre 2) présente les données **par groupe social ou territorial** (quartier prioritaire / reste de la commune, niveau de revenu, diplôme), identifie les publics **les plus éloignés** de l'offre existante (non-recours aux droits, aux soins, à l'aide alimentaire) et prévoit des **indicateurs d'équité** dès le départ (part des participants issus du public prioritaire). L'outil **« Lentille ISS »** et les guides des instances régionales de promotion de la santé aident à vérifier qu'un projet ne creuse pas les inégalités.

Présenter les inégalités dans un diagnostic : trois outils simples

1. Comparer deux territoires ou deux groupes. On présente l'indicateur pour le groupe prioritaire et pour la référence, avec l'écart en points et le rapport. Exemple fictif : surpoids des enfants de grande section, 18,5 %

dans le quartier prioritaire contre 11,2 % dans le reste de la commune ; écart **7,3 points**, rapport 18,5 / 11,2 = **1,65**.

2. Montrer un gradient. Les inégalités de santé ne séparent pas seulement les pauvres du reste de la population : la santé s'améliore à chaque échelon de l'échelle sociale. C'est le **gradient social** (chapitre 2). On le montre en présentant l'indicateur pour trois groupes ou plus (niveau de diplôme, de revenu), et pas seulement pour deux.

3. Prévoir un indicateur d'équité. Un projet ouvert à tous attire souvent les personnes les plus favorisées, qui ont plus de temps et d'informations. On fixe donc dès le diagnostic un indicateur qui vérifiera que le public prioritaire est bien touché : la **part des participants issus du public prioritaire**, comparée à son poids dans la population.

Exemple – Calcul détaillé : un indicateur d'équité

Le quartier prioritaire regroupe 32 % des habitants de la commune. Sur les 40 participants au cycle d'ateliers, 26 habitent ce quartier, soit 26 / 40 × 100 = **65,0 %**. Le rapport 65,0 / 32 = **2,03** montre que le public prioritaire est deux fois plus représenté parmi les participants que dans la population : l'objectif d'équité est atteint. Avec un rapport inférieur à 1, le projet aurait surtout touché les autres quartiers, et il aurait pu creuser les écarts.

Définition – L'universalisme proportionné

L'**universalisme proportionné** (rapport Marmot, 2010, chapitre 2) consiste à proposer une action à toute la population, avec une intensité **proportionnée** aux besoins : plus de séances, d'accompagnement ou de moyens pour les groupes les plus défavorisés. Dans un diagnostic, il se traduit par une analyse des données **par groupe social** et par le choix de lieux et de modalités qui facilitent l'accès des plus éloignés.

Attention – Mesurer le statut social avec respect

Les questions sur les revenus sont mal acceptées. On préfère des indicateurs indirects et moins intrusifs : le diplôme, la situation d'emploi, la couverture santé solidaire, le quartier de résidence, ou un score de précarité validé comme le score EPICES (présenté au chapitre 2). On explique pourquoi on pose ces questions et l'on garde la possibilité de ne pas répondre.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.28

Une enquête (fictive) auprès de 160 parents donne la part de ceux qui mangent un fruit chaque jour : sans diplôme, 14 sur 50 ; baccalauréat, 27 sur 60 ; diplôme du supérieur, 33 sur 50. a) Calculez les trois pourcentages. b) Calculez l'écart et le rapport entre les deux groupes extrêmes. c) Que montre cette présentation en trois groupes ? d) Le projet prévoit 30 places : combien de places réserver aux parents sans diplôme pour qu'ils représentent au moins la même part que dans l'enquête ?

Corrigé

a) Sans diplôme : 14 / 50 = **28,0 %** ; baccalauréat : 27 / 60 = **45,0 %** ; supérieur : 33 / 50 = **66,0 %**. b) Écart : 66,0 − 28,0 = **38,0 points** ; rapport : 66,0 / 28,0 = **2,36**. c) Un **gradient** : la consommation augmente à chaque niveau de diplôme, et pas seulement entre deux groupes. d) Les parents sans diplôme représentent 50 / 160 = **31,3 %** de l'enquête ; 0,313 × 30 = 9,4, soit **10 places** au moins (on arrondit au supérieur). Selon l'universalisme proportionné, on peut en prévoir davantage et adapter les horaires et la communication.

7.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le cadre logique et la théorie du changement

La **matrice du cadre logique** (*logical framework*) présente sur une page : en lignes, l'objectif général, les objectifs spécifiques, les résultats attendus et les activités ; en colonnes, la description, les **indicateurs objectivement vérifiables**, les **sources de vérification** et les **hypothèses** (conditions extérieures nécessaires). La **théorie du changement** (*theory of change*) explicite la chaîne causale « si… alors… » entre les activités et les effets (« si les parents savent cuisiner les lentilles à moins de 0,30 € la portion, alors ils en achèteront davantage, à condition que l'épicerie en propose en vrac »). Ces deux outils, exigés par de nombreux financeurs, préparent directement l'évaluation (chapitre 9).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Échantillonnage et inférence

Un **échantillon aléatoire simple** (tirage au sort dans une liste) permet de calculer une marge d'erreur valide ; sur le terrain, on utilise souvent un échantillon **de convenance** (les personnes disponibles) ou par **quotas** (respect de la répartition par âge, sexe, quartier). Les formules de précision ne s'appliquent alors qu'approximativement. Pour une petite population **finie** (N), la taille nécessaire se corrige : n' = n / (1 + (n − 1) / N). Exemple : population de 300 familles, n = 385 pour ± 5 points : n' = 385 / (1 + 384 / 300) = 385 / 2,28 = **168,9**, soit **169 familles**.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Les indicateurs de santé et la triangulation

La qualité d'un diagnostic repose sur la **triangulation** des sources (statistiques, données de terrain, avis d'experts et d'habitants) et des méthodes (quantitatives et qualitatives). Les indicateurs doivent être **valides** (ils mesurent ce qu'on veut mesurer), **fiables** (reproductibles), **sensibles** (ils varient quand la situation change), **disponibles** et **compréhensibles**. Les ORS publient des indicateurs **standardisés** (chapitre 2) qui permettent la comparaison entre territoires.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Comparer deux proportions : le test du khi-deux

Pour savoir si une différence entre deux groupes peut être due au hasard, on utilise le **test du khi-deux** (χ^2). Exemple du tableau de 7.3.11 : on calcule les **effectifs attendus** sous l'hypothèse d'absence de différence : pour la case « inscrites, ≥ 2 fois », attendu = (30 × 13) / 48 = **8,125** ; « inscrites, moins » = 30 × 35 / 48 = **21,875** ; « non inscrites, ≥ 2 fois » = 18 × 13 / 48 = **4,875** ; « non inscrites, moins » = 18 × 35 / 48 = **13,125**. χ^2 = Σ (observé − attendu)² / attendu = (9 − 8,125)² / 8,125 + (21 − 21,875)² / 21,875 + (4 − 4,875)² / 4,875 + (14 − 13,125)² / 13,125 = 0,0942 + 0,0350 + 0,1571 + 0,0583 = **0,345**. Le seuil pour 1 degré de liberté au risque de 5 % est **3,84** : 0,345 < 3,84, la différence **n'est pas significative**. (Quand un effectif attendu est inférieur à 5, comme ici pour une case, on préfère le test exact de Fisher.)

Pour aller plus loin – niveau L3 – La méthode Delphi

La **méthode Delphi** recueille l'avis d'un panel d'experts en plusieurs tours de questionnaires anonymes : à chaque tour, les participants reçoivent la synthèse des réponses du tour précédent et peuvent revoir leur position, jusqu'à un **consensus**. Elle est utilisée pour définir des priorités ou des indicateurs quand les données manquent (par exemple, priorités nutritionnelles d'un territoire ultramarin). Elle évite la domination de quelques personnes, mais demande du temps et un panel bien constitué.

7.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Du dossier patient au diagnostic de population

En consultation, le diététicien constate que beaucoup de patients diabétiques d'une maison de santé ne connaissent pas l'épicerie solidaire voisine. Il propose à l'équipe un diagnostic sur l'accès à l'alimentation des patients précaires, préalable à une action collective.

Situation bc2 – Diagnostic en restauration collective

Avant de modifier les menus d'un EHPAD, le diététicien croise les pesées des restes, les poids des résidents (données agrégées), un questionnaire de satisfaction et des entretiens avec les cuisiniers : c'est une démarche de diagnostic identique à celle du BC3.

Situation bc3 – Une demande à reformuler

Un principal de collège demande « une conférence sur l'obésité ». Le diététicien propose d'abord un diagnostic (questionnaire aux élèves sur le petit-déjeuner et les collations, entretien avec l'infirmière, observation du self) avant de définir l'action.

Situation bc3 – Prioriser sur un territoire rural

Un pôle d'équilibre territorial demande d'agir sur l'alimentation des seniors isolés et sur la restauration scolaire. Le diététicien applique la méthode de Hanlon avec le comité de pilotage et argumente le choix d'une priorité unique pour la première année.

Situation bc3 – Une problématique à reformuler

Une stagiaire propose comme problématique « Est-ce que les enfants mangent assez de légumes ? ». Sa tutrice l'aide à la reformuler à partir de son diagnostic : « Comment augmenter la consommation de légumes des enfants de l'accueil de loisirs, qui rejettent les légumes peu familiers, en s'appuyant sur l'exposition répétée et la participation à la cuisine ? »

Situation bc3 – Un marais alimentaire

Un repérage autour d'un collège montre 6 établissements de restauration rapide dans un rayon de 500 m et aucun commerce de fruits. Le diététicien en fait un argument de plaidoyer auprès de la commune et de l'intercommunalité (PAT), en complément de l'action éducative au collège.

Cas guidé : le diagnostic des goûters d'un accueil de loisirs

Ce cas reprend toute la démarche du chapitre sur un exemple court. Toutes les données sont fictives. Lisez chaque étape, puis cachez la réponse et essayez de la retrouver.

Situation professionnelle – Le contexte

L'accueil de loisirs intercommunal de Montferrand (fictif) reçoit 96 enfants de 6 à 11 ans le mercredi et pendant les vacances. Le goûter est apporté par les familles. La directrice a remarqué « beaucoup de gâteaux et de sodas » et demande à Lina, stagiaire en BTS, de « faire quelque chose sur les goûters ». Lina dispose de

six semaines.

Étape 1. Reformuler la demande. La demande est une solution floue (« faire quelque chose »). Lina propose d'abord un diagnostic de quatre semaines, validé par la directrice et par le service enfance de l'intercommunalité (comité de pilotage).

Étape 2. Choisir les méthodes. Lina combine une **observation** des goûters (grille, cinq mercredis, avec l'accord des parents), un **questionnaire** court aux parents (10 questions, distribué à l'accueil du soir, version orale possible), deux **entretiens** (directrice, deux animateurs) et un **groupe d'expression** avec 8 enfants (photolangage d'aliments).

Exemple – Étape 3. Les résultats de l'observation

En moyenne, 82 goûters ont été observés chaque mercredi. Un goûter peut contenir plusieurs aliments.

Contenu du goûter	Goûters concernés	Pourcentage (n = 82)
Biscuit ou viennoiserie industriels	52	63,4 %
Boisson sucrée (soda, jus, boisson aromatisée)	35	42,7 %
Eau seule comme boisson	30	36,6 %
Produit laitier	19	23,2 %
Fruit frais ou compote	14	17,1 %

Calcul : 52 / 82 × 100 = **63,4 %** ; 14 / 82 × 100 = **17,1 %**. Moins d'un goûter sur cinq contient un fruit.

Exemple – Étape 4. Le questionnaire aux parents

57 questionnaires sont revenus sur 96, soit 57 / 96 × 100 = **59,4 %** (dont 11 remplis à l'oral). Raisons données pour le choix du goûter (plusieurs réponses possibles) : l'enfant refuse les fruits, 31 parents (**54,4 %**) ; pas le temps de préparer, 23 (**40,4 %**) ; le goûter industriel est « équilibré » parce qu'il est enrichi en vitamines, 20 (**35,1 %**) ; le prix des fruits, 12 (**21,1 %**). Les animateurs ajoutent que les fruits apportés reviennent souvent intacts, faute de temps et de couteau pour les couper.

Étape 5. Poser le diagnostic. Problème central : « Les goûters des enfants de l'accueil de loisirs sont riches en produits sucrés et pauvres en fruits. » Causes avec leurs faits : refus des fruits par les enfants (facteur de renforcement, 54,4 % des parents) ; manque de temps des parents (facteur facilitant, 40,4 %) ; croyance que les biscuits enrichis sont équilibrés (facteur prédisposant, 35,1 %) ; organisation du goûter qui ne permet pas de couper les fruits (environnement, entretiens). Conséquences : apports élevés en sucres ajoutés, risque carieux, habitudes de goût sucré.

Exemple – Étape 6. Prioriser avec la méthode de Hanlon

Le comité note trois problèmes (A, B et C de 0 à 10).

- Boissons sucrées : (5 + 2 × 6) × 7 / 3 = 17 × 7 / 3 = 119 / 3 = **39,7**.
- Goûters très sucrés : (7 + 2 × 5) × 6 / 3 = 17 × 6 / 3 = 102 / 3 = **34,0**.
- Peu de fruits : (6 + 2 × 4) × 5 / 3 = 14 × 5 / 3 = 70 / 3 = **23,3**.

Le test PEARL est positif pour les trois problèmes. Le comité retient les boissons sucrées en priorité (eau proposée par le centre, facile à mettre en place) et intègre les fruits dans une seconde action, car la cause organisationnelle (couper les fruits) est simple à lever.

Étape 7. Rédiger les objectifs. Objectif général : contribuer à améliorer la qualité nutritionnelle des goûters des enfants de l'accueil de loisirs. Objectif spécifique 1 : « D'ici la fin des vacances de printemps, la part des goûters

contenant une boisson sucrée passe de 42,7 % à 20 % au plus (grille d'observation, cinq mercredis). » Objectif spécifique 2 : « D'ici la même date, au moins 40 % des goûters contiennent un fruit (contre 17,1 %), soit au moins 33 goûters sur 82. » Objectifs opérationnels : installer une fontaine à eau et des gobelets réutilisables dès la rentrée de janvier ; organiser un atelier « fruits à croquer » chaque mercredi pendant huit semaines ; diffuser aux familles un document illustré de quatre idées de goûters rapides à moins de 0,50 € (calculées avec les prix relevés).

Astuce – Ce que montre ce cas

Le diagnostic a transformé une demande vague en deux objectifs mesurables. Il a aussi révélé une cause que personne n'avait formulée : l'organisation du goûter (pas de couteau, pas de temps). L'action la plus simple, couper les fruits sur place, découle directement de l'observation, et non d'une idée de départ.

Méthodes pour l'épreuve E5 : réussir les questions de diagnostic

Dans les sujets de l'épreuve E5, le diagnostic revient sous plusieurs formes : « Analysez la situation à partir des documents », « Identifiez les besoins du public », « Construisez l'arbre à problèmes », « Hiérarchisez les priorités », « Formulez les objectifs », « Proposez un outil de recueil ». Les méthodes suivantes permettent de répondre de façon structurée et de gagner du temps.

Formulation de la question	Ce qui est attendu
« Analysez la situation »	Les données utiles des documents, organisées (territoire, public, santé, comportements, offre, ressources), chacune sourcée et interprétée
« Identifiez les besoins »	Des besoins classés selon Bradshaw, chacun appuyé par un élément précis du document
« Calculez »	Le calcul posé (formule, valeurs, résultat avec unité) et une phrase d'interprétation
« Construisez l'arbre à problèmes »	Un problème central, des causes classées et appuyées par des faits, des conséquences
« Hiérarchisez » ou « priorisez »	Des critères explicites, une méthode (Hanlon, grille) et un classement justifié
« Formulez les objectifs »	Un objectif général, des objectifs spécifiques SMART centrés sur le public, des objectifs opérationnels
« Proposez un outil de recueil »	L'outil choisi, sa justification, quelques questions rédigées, les modalités de passation et les limites

Méthode 1 – Exploiter un dossier documentaire en dix minutes

1. Lire le sujet en entier avant les documents, et souligner ce que chaque question demande.

2. Parcourir chaque document en notant en marge sa source, sa date et son type (statistique, témoignage, extrait de politique).

3. Classer les informations dans une grille rapide : territoire, public, santé, comportements, offre, ressources, besoins exprimés.

4. Repérer les chiffres à comparer : un chiffre local et un chiffre de référence, pour la même année et la même tranche d'âge.

5. Repérer les manques : ce que les documents ne disent pas, qui justifiera un outil de recueil complémentaire.

Méthode 2 – Rédiger une analyse de données sans paraphraser

Un paragraphe d'analyse suit quatre temps : le **chiffre** (avec la source), la **comparaison** (référence, écart en

points ou rapport), l'**interprétation** (ce que cela signifie pour le public) et la **conséquence** pour le projet. Paraphraser un document (« le document 2 dit que 38 % des enfants… ») sans comparaison ni interprétation ne rapporte presque aucun point.

Exemple – Un paragraphe d'analyse complet

« Selon le document 2 (bilan de santé scolaire 2025, données fictives), 38 % des élèves de CM2 de l'école ne prennent pas de petit-déjeuner avant de venir en classe, contre 21 % pour l'ensemble des écoles de la circonscription, soit 17 points de plus et un rapport de 1,81. Le petit-déjeuner absent concerne donc près de deux élèves sur cinq, ce qui peut gêner la concentration en fin de matinée. Ce constat justifie d'interroger les familles sur les causes (horaires, habitudes, coût) avant de proposer une action. »

Méthode 3 – Construire un arbre à problèmes à l'écrit

Sur une copie, l'arbre peut être présenté sous forme de schéma simple ou de tableau. Placez le problème central au centre, trois à cinq causes en dessous, réparties dans au moins deux familles (individuelles et environnementales), et deux ou trois conséquences au-dessus. Pour chaque cause, ajoutez entre parenthèses le numéro du document qui l'appuie (« doc. 3 »). Un arbre sans renvoi aux documents ressemble à un arbre « imaginé ».

Attention – Les erreurs qui coûtent le plus de points

Confondre écart en points et variation relative ; présenter un objectif opérationnel comme un objectif spécifique ; oublier l'échéance d'un objectif ; formuler le problème central comme une absence de solution ; citer une donnée nationale comme si elle était locale ; ne pas poser les calculs ; arrondir les effectifs cibles à l'inférieur.

Méthode 4 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve

Chaque affirmation suivante contient une erreur fréquente dans les copies. Lisez-la, trouvez l'erreur, puis vérifiez avec la correction.

Affirmation fausse	Correction
« Passer de 20 % à 30 %, c'est une hausse de 10 %. »	C'est une hausse de 10 points, soit une hausse relative de 50 %.
« Le besoin exprimé est ce que les personnes ressentent. »	Le besoin ressenti est ce que les personnes perçoivent ; le besoin exprimé est une demande qui se manifeste (inscriptions, listes d'attente, demandes formulées).
« Le problème central est le manque d'ateliers. »	C'est une solution déguisée ; le problème central décrit une situation du public.
« Les opportunités sont les forces de la structure. »	Les opportunités sont externes ; les forces sont internes.
« Dans la méthode de Hanlon, les trois critères comptent autant. »	La gravité compte double : (A + 2B) × C / 3.
« Un objectif spécifique décrit ce que l'équipe va faire. »	Il décrit un changement chez le public ; ce que fait l'équipe relève des objectifs opérationnels.
« 60 % de 12 familles, c'est 7 familles. »	0,60 × 12 = 7,2 : il faut 8 familles au moins pour atteindre 60 %.
« Un questionnaire de 40 questions est plus complet, donc meilleur. »	Un questionnaire trop long fait baisser le taux de réponse ; on garde les questions utiles au diagnostic.

Affirmation fausse	Correction
« Avec 385 personnes, on est sûr du résultat. »	La marge de ± 5 points suppose un tirage au hasard ; un échantillon de convenance reste exposé au biais de sélection.
« 12 parents sur 20 : on écrit 60 %. »	Sous 20 répondants, on donne d'abord l'effectif : « 12 parents sur 20 ».
« Une association dans un tableau croisé prouve une cause. »	Elle peut venir d'un facteur de confusion ; on parle d'association ou de tendance.
« 17 % des adultes du quartier sont obèses (Esteban). »	Esteban est une étude nationale : on écrit « en France » et l'on donne les années.
« La médiane est toujours égale à la moyenne. »	La médiane partage les données classées en deux moitiés ; elle diffère de la moyenne quand il existe des valeurs extrêmes.
« Le prétest se fait auprès de collègues. »	Il se fait auprès de 3 à 5 personnes du public visé.
« La restitution se fait à la fin du projet. »	La restitution du diagnostic se fait avant de décider des priorités : elle valide les résultats.

Méthode 5 – Relier le diagnostic aux autres chapitres

Le jury apprécie qu'un candidat relie le diagnostic aux autres savoirs du BTS. Le tableau suivant indique les liens les plus utiles.

Notion du chapitre 7	Chapitre à mobiliser	Usage dans une copie ou à l'oral
Besoins, indicateurs, inégalités	Chapitre 2	Déterminants, gradient social, prévalence et incidence
Causes de l'arbre à problèmes	Chapitres 3 et 4	Représentations, normes sociales, comportements alimentaires
Questionnaire accessible	Chapitre 5	Littératie en santé, documents faciles à lire
Consentement, anonymat, restitution	Chapitre 6	Principes éthiques, RGPD, droit à l'image
Plan d'action, stratégies FFOM	Chapitre 8	Passage des objectifs aux actions
Indicateurs, valeur initiale	Chapitre 9	Évaluation des résultats et du processus
Mesure des consommations	Chapitres 4 et 18	Méthodes d'enquête alimentaire, démarche d'étude
Échantillon, confusion	Chapitre 16	Épidémiologie, biais, association et causalité
Données nationales	Chapitre 17	Grandes études et organismes producteurs

Méthode 6 – Défendre son diagnostic à l'oral

À l'oral, le jury vérifie que le candidat a réellement mené son diagnostic et qu'il sait en reconnaître les limites. Préparez une réponse courte (trois ou quatre phrases) à chacune des questions suivantes.

Questions probables du jury – Sur le diagnostic

- Pourquoi avez-vous choisi ce questionnaire plutôt que des entretiens ? (ou l'inverse)
- Combien de personnes avez-vous interrogées, où et quand ? Votre échantillon est-il représentatif ?
- Quelle est la principale limite de votre recueil, et comment l'avez-vous réduite ?
- Pourquoi avez-vous retenu ce problème plutôt qu'un autre ?
- Quelle cause n'avez-vous pas retenue, et qui peut agir dessus ?
- Comment saurez-vous que votre objectif spécifique est atteint ?
- Qu'avez-vous restitué au public, et qu'est-ce que la restitution a changé ?

Préparer l'oral – Une réponse modèle

Question : « Votre échantillon est-il représentatif ? » Réponse : « Pas entièrement. J'ai interrogé 48 parents à la sortie des écoles et à l'épicerie solidaire, ce qui sous-représente les parents qui travaillent tôt. Pour réduire ce biais, j'ai ajouté une passation orale à l'épicerie le samedi et un groupe de parole. Je présente donc mes résultats comme des tendances, avec les effectifs, et je les ai croisés avec les données de la PMI. »

7.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Démarche et analyse de situation

- **Projet** : actions coordonnées, limitées dans le temps, avec des moyens, pour des objectifs, en réponse à un besoin ; **cycle** : analyse → diagnostic et priorités → objectifs → plan d'action → mise en œuvre → évaluation → valorisation.
- **Besoins** (Bradshaw, 1972) : normatif, ressenti, exprimé, comparatif ; **triangulation**.
- **Sources** : Insee, Géodes, ORS, Data pathologies, INCA 3, Esteban, Albane ; terrain ; politiques (PNNS 5, PRS, CLS, PAT) ; toujours **source + date**.
- **Recueil** : questionnaire (8 étapes, prétest), entretien semi-directif, groupe de parole, observation, relevé de l'offre ; **biais** de sélection, de non-réponse, de désirabilité sociale, de mémoire.
- **Précision** : $e = 1{,}96 \times \sqrt{p(1-p)/n}$; $n = 1{,}96^2 \times p(1-p)/e^2$ (385 pour ± 5 points) ; petits effectifs → donner les effectifs.
- **Calculs** : pourcentage, écart en points ≠ variation relative, rapport, moyenne, médiane.

À retenir – Diagnostic, priorités, objectifs

- **Problème central** : situation négative, observable, mesurable (pas une absence de solution).
- **Arbre à problèmes** : causes (avec faits) → problème → conséquences ; **FFOM** : forces et faiblesses internes, opportunités et menaces externes.
- **Hanlon** : (A + 2B) × C / 3 + test **PEARL** (un 0 écarte le problème).
- **Objectifs** : général (contribution, long terme) → spécifiques (changements chez le public, SMART) → opérationnels (ce que fait l'équipe, SMART) ; verbes observables ; **arbre à objectifs**.
- **Valeur cible** : effectif = pourcentage × total, arrondi au supérieur.

À retenir – Compléments : échantillon, participation, environnement, problématique

- **Échantillonnage** : aléatoire simple, systématique (pas k = N / n), stratifié (proportionnel), grappes, quotas, convenance (biais de sélection).
- **Méthodes participatives** : photolangage, photovoice, marche exploratoire, cartographie, world café ; **groupe nominal** (vote pondéré 5-4-3-2-1).
- **Environnement alimentaire** : densité, distance, indice favorable / (favorable + défavorable) × 100 ; désert et marais alimentaires.
- **Tableaux croisés** : pourcentages dans le sens des groupes comparés ; prudence sur les petits effectifs (khi-deux en L3).
- **Problématique** : constat → tension → public, lieu, levier → question ouverte (« comment… ? ») ; cohérence problème central / problématique / objectif général.
- **FFOM croisée** : offensive (F × O), amélioration (Fa × O), défensive (F × M), survie (Fa × M).

7.8 Entraînement

7.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Un projet de santé publique :

a) est limité dans le temps **b)** vise la santé d'une population **c)** commence par le choix de l'action **d)** répond à un besoin identifié

QCM 2 – Le besoin exprimé correspond :

a) à une norme fixée par des experts **b)** à une demande formulée par les personnes **c)** à un écart entre deux territoires **d)** par exemple à une liste d'attente pour des ateliers

QCM 3 – « 14 % d'enfants en surpoids dans le quartier contre 9 % dans le département » illustre un besoin :

a) normatif **b)** ressenti **c)** exprimé **d)** comparatif

QCM 4 – Une question bien rédigée dans un questionnaire :

a) contient une seule idée **b)** oriente la réponse **c)** propose des modalités exhaustives et exclusives **d)** utilise des termes techniques précis

QCM 5 – Le biais de désirabilité sociale conduit à :

a) surdéclarer les fruits et légumes **b)** sous-déclarer les sodas **c)** interroger seulement les volontaires **d)** oublier des consommations anciennes

QCM 6 – Pour une marge d'erreur de ± 5 points avec p inconnu, il faut environ :

a) 48 personnes **b)** 97 personnes **c)** 385 personnes **d)** 1 000 personnes

QCM 7 – Passer de 20 % à 30 % correspond à :

a) une hausse de 10 points **b)** une hausse relative de 50 % **c)** une hausse de 10 % **d)** une hausse relative de 33 %

QCM 8 – Le problème central d'un arbre à problèmes :

a) est une situation négative observable **b)** peut être « absence d'ateliers » **c)** est au centre, entre causes et conséquences **d)** doit être mesurable si possible

QCM 9 – Dans l'analyse FFOM, sont externes :

a) les forces **b)** les opportunités **c)** les menaces **d)** les faiblesses

QCM 10 – Dans la méthode de Hanlon :

a) le score est (A + 2B) × C / 3 **b)** la gravité compte double **c)** un 0 au test PEARL écarte le problème **d)** l'ampleur compte triple

QCM 11 – Un objectif spécifique :

a) décrit un changement attendu chez le public **b)** décrit ce que fait l'équipe **c)** doit être SMART **d)** correspond à une cause retenue de l'arbre

QCM 12 – « Animer 6 ateliers de mars à mai » est un objectif :

a) général **b)** spécifique **c)** opérationnel **d)** d'impact

QCM 13 – Parmi ces verbes, lesquels conviennent à un objectif observable ?

a) prendre conscience **b)** citer **c)** cuisiner **d)** comprendre

QCM 14 – Le modèle PRECEDE-PROCEED :

a) part de la qualité de vie de la population **b)** distingue facteurs prédisposants, facilitants et de renforcement **c)** a été proposé par Green et Kreuter **d)** commence par la mise en œuvre

QCM 15 – Les contrats locaux de santé :

a) sont signés entre l'ARS et une collectivité **b)** s'appuient sur un diagnostic local **c)** sont prévus par le Code de la santé publique **d)** remplacent le PNNS

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, b, d. 2. **b, d**. 3. **d**. 4. **a, c**. 5. **a, b**. 6. **c** (n = 384,2 → 385). 7. **a, b** ((30 − 20) / 20 × 100 = 50 %). 8. **a, c, d** (b est une solution déguisée). 9. **b, c**. 10. **a, b, c**. 11. **a, c, d**. 12. **c**. 13. **b, c**. 14. **a, b, c**. 15. **a, b, c**.

QCM 16 – Dans un échantillonnage systématique de 40 élèves parmi 280 :

a) le pas de sondage est de 7 **b)** le pas de sondage est de 40 **c)** on tire au hasard un point de départ entre 1 et 7 **d)** on interroge les 40 premiers de la liste

QCM 17 – La technique du groupe nominal :

a) commence par une réflexion individuelle silencieuse **b)** permet à chacun de s'exprimer **c)** se termine par un vote **d)** est réservée aux experts

QCM 18 – Un marais alimentaire désigne :

a) un territoire sans commerce **b)** un territoire où l'offre défavorable domine l'offre favorable **c)** une zone humide agricole **d)** un territoire où la restauration rapide est très présente

QCM 19 – Une bonne problématique :

a) est une question ouverte **b)** part du diagnostic **c)** se répond par oui ou non **d)** précise le public et le levier d'action

QCM 20 – Dans la matrice FFOM croisée, la stratégie « forces × opportunités » est dite :

a) offensive **b)** défensive **c)** de survie **d)** d'amélioration

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM complémentaires

16. a, c (280 / 40 = 7). 17. **a, b, c**. 18. **b, d**. 19. **a, b, d**. 20. **a**.

7.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les besoins de Bradshaw

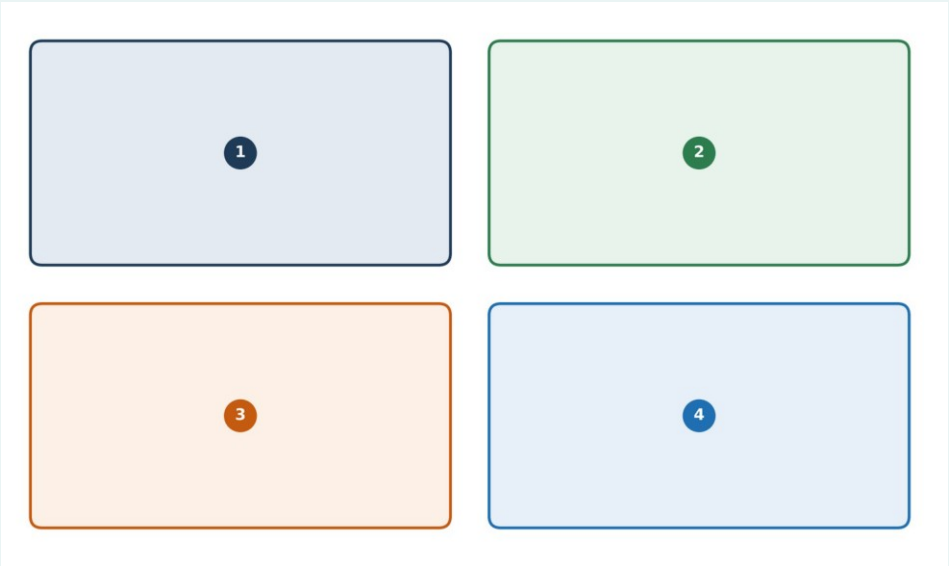


Figure 7.10 – Schéma à légender

Nommez les besoins 1 à 4 et classez les données suivantes : a) 58 % des parents ne savent pas cuisiner les

légumes secs ; b) 26 parents demandent des ateliers ; c) 27 % des familles atteignent le repère « légumes secs 2 fois par semaine » ; d) taux de pauvreté de 41 % contre 15 % dans la commune.

Corrigé

1. Normatif. 2. **Ressenti**. 3. **Exprimé**. 4. **Comparatif**. Classement : a) ressenti (difficulté perçue) ; b) exprimé ; c) normatif (comparaison au repère) ; d) comparatif.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : l'arbre à problèmes

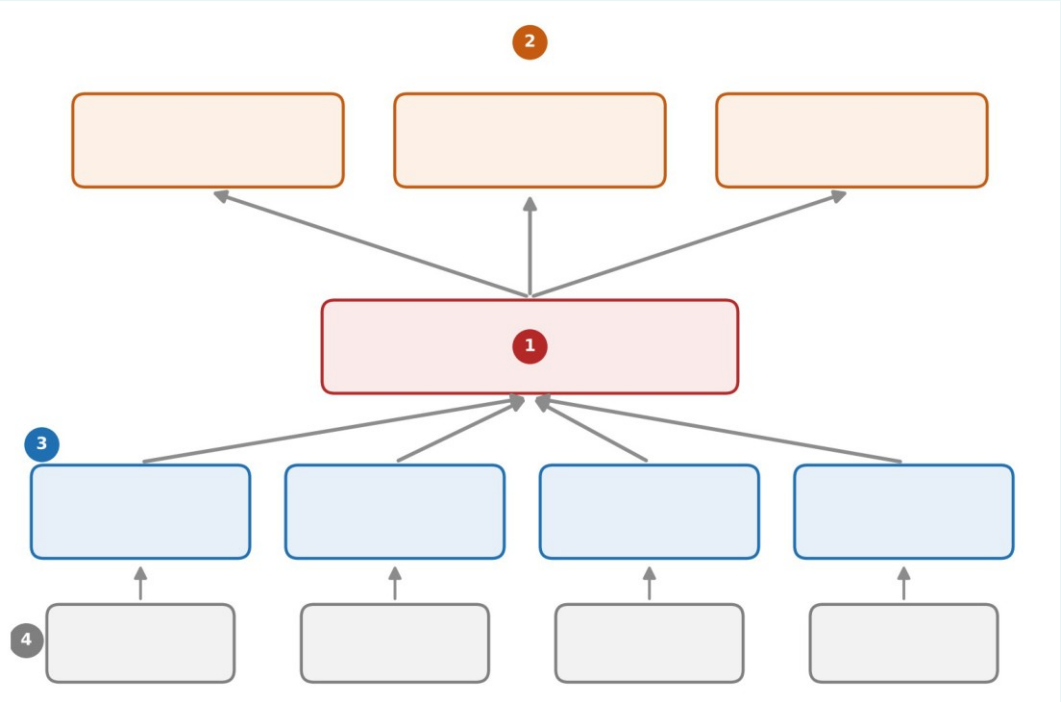


Figure 7.11 – Schéma à légender

Légendez les éléments 1 à 4, puis complétez l'arbre pour la situation suivante : dans un internat de lycée, 35 % des élèves sautent le petit-déjeuner au moins 3 fois par semaine.

Corrigé

1. Problème central. 2. **Conséquences**. 3. **Causes**. 4. **Faits du diagnostic**. Exemple : problème : saut fréquent du petit-déjeuner chez 35 % des internes. Causes : horaires (lever tardif, service de 7 h à 7 h 30) ; absence de faim (dîner tardif, écrans) ; offre peu attractive ; recherche de minceur chez certains. Conséquences : fatigue et baisse de concentration en fin de matinée, grignotage à la récréation, apports insuffisants en calcium et fibres.

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : la hiérarchie des objectifs

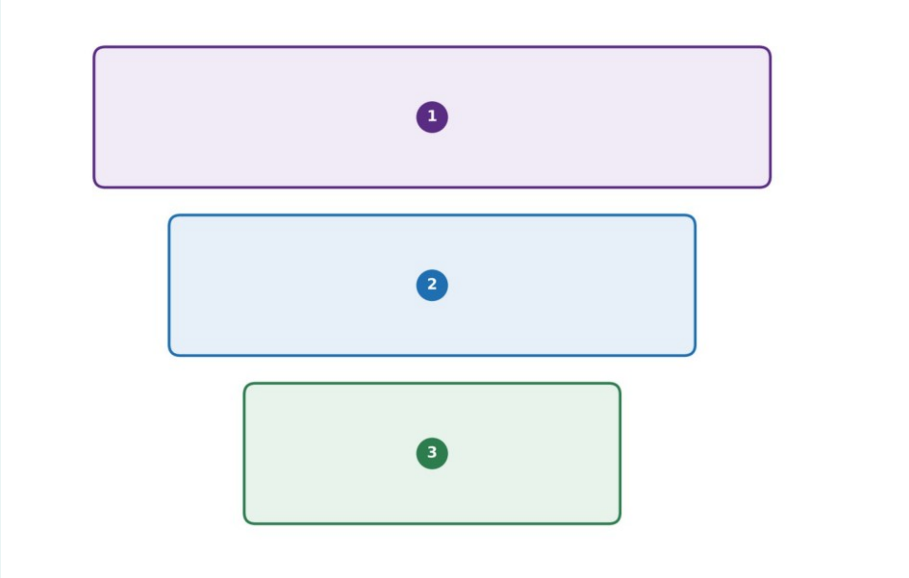


Figure 7.12 – Schéma à légender

Nommez les niveaux 1 à 3 et classez : a) « Contribuer à améliorer l'état nutritionnel des internes » ; b) « Proposer un petit-déjeuner à emporter les jours de cours à 8 h » ; c) « D'ici juin, au moins 80 % des internes prennent un petit-déjeuner au moins 4 jours sur 5 ».

Corrigé

1. Objectif général – a. 2. **Objectifs spécifiques** – c. 3. **Objectifs opérationnels** – b.

À vous de jouer – Exercice 4 – Calculer la précision

Dans un questionnaire auprès de 150 étudiants, 42 % déclarent sauter le petit-déjeuner. Calculez la marge d'erreur à 95 % et l'intervalle de confiance. Combien d'étudiants faudrait-il interroger pour une marge de ± 4 points (p = 0,42) ?

Corrigé

p = 0,42 ; 1 − p = 0,58 ; p(1 − p) = 0,2436 ; / 150 = 0,001624 ; √0,001624 = 0,0403 ; × 1,96 = **0,079**, soit **± 7,9 points**. IC 95 % : 42 − 7,9 = **34,1 %** à 42 + 7,9 = **49,9 %.** n = $1{,}96^2 \times 0{,}42 \times 0{,}58 / 0{,}04^2$ = 3,8416 × 0,2436 / 0,0016 = 0,93581 / 0,0016 = **584,9**, soit **585 étudiants**.

À vous de jouer – Exercice 5 – Corriger un questionnaire

Corrigez les questions suivantes : a) « Mangez-vous suffisamment de fruits et légumes et de produits laitiers ? » ; b) « Combien de fois buvez-vous des sodas : 0 / 1-3 / 3-5 / plus » ; c) « Ne pensez-vous pas que la cantine est trop chère ? »

Corrigé

a) Question double et terme subjectif (« suffisamment ») → « Hier, combien de portions de fruits avez-vous mangées ? » puis même question pour les légumes, puis pour les produits laitiers. b) Période absente, modalités qui se chevauchent (3) → « La semaine dernière, combien de fois avez-vous bu un soda ? Jamais / 1 à 2 fois / 3 à 5 fois / 6 fois ou plus. » c) Question orientée et négative → « Comment jugez-vous le prix de la cantine ? Très abordable / abordable / cher / trop cher / ne sait pas. »

À vous de jouer – Exercice 6 – Calculs du diagnostic

Dans une commune, 18 % des enfants de 6 ans sont en surpoids (obésité comprise) contre 12 % dans la région. Sur 240 enfants examinés dans la commune, combien sont en surpoids ? Calculez l'écart en points, le rapport et la variation relative.

Corrigé

Effectif : 0,18 × 240 = **43,2**, soit environ **43 enfants**. Écart : 18 − 12 = **6 points**. Rapport : 18 / 12 = **1,5** (prévalence 1,5 fois plus élevée). Variation relative : (18 − 12) / 12 × 100 = **+ 50 %**. Formulation : « La prévalence du surpoids est de 18 % dans la commune, soit 6 points (ou 50 %) de plus que dans la région (12 %) » ; ne pas écrire « 6 % de plus ».

À vous de jouer – Exercice 7 – Méthode de Hanlon

Calculez les scores et classez : P1 (A = 8, B = 5, C = 6) ; P2 (A = 4, B = 9, C = 5) ; P3 (A = 6, B = 6, C = 8 ; mais aucun financement possible et coût élevé).

Corrigé

P1 : (8 + 2 × 5) × 6 / 3 = (8 + 10) × 6 / 3 = 18 × 6 / 3 = 108 / 3 = **36,0**. P2 : (4 + 2 × 9) × 5 / 3 = (4 + 18) × 5 / 3 = 22 × 5 / 3 = 110 / 3 = **36,7**. P3 : (6 + 12) × 8 / 3 = 18 × 8 / 3 = 144 / 3 = **48,0**, mais test PEARL : Économie = 0 et Ressources = 0 → **écarté**. Classement : **P2 (36,7) > P1 (36,0)** ; les deux scores étant très proches, la décision se discute avec le comité (acceptabilité, demande des habitants) ; P3 est écarté malgré le meilleur score.

À vous de jouer – Exercice 8 – Rédiger des objectifs SMART

Diagnostic dans une épicerie solidaire (90 foyers) : 30 % des foyers achètent des légumes frais chaque semaine ; 64 % ne connaissent pas les recettes à base de légumes secs ; la structure peut organiser un atelier par mois. Rédigez un objectif général, deux spécifiques et deux opérationnels, avec les valeurs cibles en effectifs.

Corrigé

Général : contribuer à améliorer la qualité de l'alimentation des foyers bénéficiaires de l'épicerie. **Spécifique 1** : d'ici 12 mois, au moins 45 % des foyers achètent des légumes frais chaque semaine (contre 30 %) ; effectif : 0,45 × 90 = 40,5 → **41 foyers** (contre 0,30 × 90 = 27). **Spécifique 2** : d'ici 12 mois, au moins la moitié des foyers participants savent préparer une recette à base de légumes secs (observation en atelier). **Opérationnel 1** : animer 10 ateliers culinaires d'ici 12 mois (un par mois, hors juillet-août), de 8 personnes. **Opérationnel 2** : proposer chaque mois une dégustation et une fiche recette à la caisse de l'épicerie.

À vous de jouer – Exercice 9 – Analyse FFOM

Réalisez l'analyse FFOM d'un service de restauration scolaire qui veut lancer un projet « goûter et éducation au goût » : cuisine centrale avec diététicienne ; animateurs périscolaires motivés mais peu formés ; budget denrées contraint ; PAT de l'agglomération favorisant les produits locaux ; hausse des prix ; parents peu impliqués.

Corrigé

Forces : cuisine centrale, diététicienne, animateurs motivés. **Faiblesses** : animateurs peu formés, budget contraint. **Opportunités** : PAT (produits locaux, financement possible), politiques nationales (PNNS, EGalim). **Menaces** : inflation, faible implication des parents. **Stratégie** : former les animateurs (corriger une faiblesse) en s'appuyant sur la diététicienne (force) ; solliciter le PAT pour des produits locaux (opportunité) ; associer les parents par un goûter partagé (réduire une menace).

À vous de jouer – Exercice 10 – Analyse thématique

Voici des extraits d'un groupe de parole de 6 personnes âgées : « Je ne cuisine plus pour moi toute seule » (3 fois) ; « Les courses sont lourdes à porter » (4 fois) ; « J'ai moins faim qu'avant » (5 fois) ; « J'aime manger avec les autres » (4 fois). Présentez les thèmes dans un tableau avec effectifs et pourcentages et proposez deux pistes.

Corrigé

Thèmes classés : perte d'appétit 5/6 = **83,3 %** ; courses lourdes 4/6 = **66,7 %** ; plaisir de manger ensemble 4/6 = **66,7 %** ; ne plus cuisiner pour soi 3/6 = **50 %**. Avec 6 personnes, présenter surtout les **effectifs**. Pistes : repas partagés (facilitation sociale, lutte contre la perte d'appétit) ; organisation de livraisons ou de courses accompagnées ; enrichissement des repas (repérage de la dénutrition en lien avec le médecin).

7.8.3 Questions de réflexion

À vous de jouer – Question 1

Pourquoi ne faut-il pas commencer un projet par le choix de l'action ?

Corrigé

Parce que l'action risque de ne pas répondre aux besoins réels (ni aux causes du problème), de ne pas toucher le bon public et d'être impossible à évaluer faute d'objectifs et d'état initial. Le diagnostic justifie l'action devant le public, les partenaires, les financeurs et le jury ; il garantit la pertinence et l'utilisation efficace des ressources.

À vous de jouer – Question 2

Un besoin normatif non ressenti doit-il être traité ?

Corrigé

Oui, s'il est important pour la santé (gravité, ampleur), mais en commençant par un travail de **sensibilisation** et d'écoute pour comprendre pourquoi il n'est pas ressenti (priorités de vie, représentations). Imposer une action sans adhésion échoue souvent ; on cherche à relier le besoin normatif aux préoccupations des personnes (budget, enfants, plaisir).

À vous de jouer – Question 3

Quelles sont les limites d'un diagnostic réalisé en deux semaines de stage ?

Corrigé

Petit échantillon de convenance, biais de sélection et de désirabilité, données déclaratives, absence de certaines populations (personnes isolées, travailleurs), temps limité pour la participation des habitants. On les compense par la triangulation, l'usage des diagnostics existants (CLS, ORS), la prudence dans l'interprétation et la description honnête des limites.

7.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – Le restaurant universitaire et les étudiants précaires

Une université de 12 000 étudiants constate la hausse de la fréquentation de son épicerie solidaire (de 280 à 420 inscrits en un an). Le service de santé étudiante vous demande un diagnostic sur l'alimentation des étudiants précaires. Données disponibles : enquête interne auprès de 600 étudiants (répondants volontaires) : 31 % sautent au moins un repas par jour pour des raisons financières ; 22 % ne mangent jamais au restaurant universitaire ; 47 % n'ont qu'une plaque de cuisson ; 18 % déclarent ne pas savoir cuisiner.

1. Calculez la hausse des inscrits à l'épicerie (en effectif et en pourcentage) et la marge d'erreur du chiffre de 31 %.
2. Classez les données selon la taxonomie de Bradshaw et proposez des données complémentaires à recueillir (sources et méthodes).
3. Formulez un problème central et construisez un arbre à problèmes (au moins 4 causes).
4. Priorisez deux problèmes avec la méthode de Hanlon (notes justifiées).
5. Rédigez les objectifs (1 général, 3 spécifiques, 3 opérationnels).

Corrigé

1. Hausse : 420 − 280 = **140 inscrits** ; (420 − 280) / 280 × 100 = **+ 50 %**. Marge : p = 0,31 ; 0,31 × 0,69 = 0,2139 ; / 600 = 0,0003565 ; √ = 0,01888 ; × 1,96 = **0,037**, soit **± 3,7 points** (IC : 27,3 % – 34,7 %) ; mais échantillon de **volontaires** : biais de sélection possible, la marge réelle est plus grande.
2. Comparatif / ressenti : sauter un repas pour raisons financières (ressenti, indicateur de précarité) ; exprimé : hausse des inscriptions à l'épicerie ; ressenti : ne pas savoir cuisiner ; normatif : à construire (comparer les consommations aux repères). Données complémentaires : entretiens avec l'assistante sociale et l'épicerie, groupe de parole, observation du restaurant universitaire (horaires, prix, files d'attente), données du CROUS sur la fréquentation et le repas à 1 € pour les boursiers et étudiants précaires, enquêtes nationales sur la précarité étudiante.
3. Problème central : « Près d'un tiers des étudiants interrogés sautent au moins un repas par jour pour des raisons financières. » Causes : ressources insuffisantes (bourses, emplois) ; faible utilisation du restaurant universitaire (horaires, méconnaissance des tarifs sociaux, éloignement) ; équipement de cuisine limité ; compétences culinaires faibles ; isolement. Conséquences : fatigue, difficultés de concentration, dégradation de la santé mentale, échec universitaire.
4. Exemple : P1 « repas sautés » (A 8, B 7, C 6 → (8 + 14) × 6 / 3 = **44,0**) ; P2 « compétences culinaires » (A 4, B 4, C 7 → (4 + 8) × 7 / 3 = **28,0**). P1 prioritaire, en agissant notamment sur l'accès au restaurant universitaire.
5. Général : contribuer à améliorer la sécurité alimentaire des étudiants. Spécifiques : d'ici la fin de l'année, réduire de 31 % à 20 % la part des étudiants interrogés qui sautent un repas pour raisons financières ; au moins 60 % des inscrits à l'épicerie connaissent les tarifs sociaux du restaurant universitaire ; au moins 50 % des participants aux ateliers réalisent une recette « une plaque » à moins de 2 €. Opérationnels : campagne d'information sur les tarifs sociaux dans 10 lieux du campus ; 8 ateliers « cuisine une plaque » de 10 étudiants ; partenariat épicerie-restaurant universitaire pour des repas à emporter.

7.8.5 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Quelle est la différence entre un objectif spécifique et un objectif opérationnel ? »

Corrigé

L'objectif spécifique décrit le changement attendu chez le public (connaissances, comportements, environnement) ; l'objectif opérationnel décrit ce que l'équipe réalise pour y parvenir (ateliers, supports). Tous deux sont SMART.

Mise en situation – MSE 2

Votre tutrice vous dit : « Le diagnostic, on n'a pas le temps, on fait les ateliers directement. »

Corrigé

Je propose un diagnostic **allégé** et rapide : données existantes (CLS, rapport d'activité), 3 entretiens, un questionnaire court lors du premier atelier (qui servira aussi d'état initial pour l'évaluation) ; j'explique que c'est indispensable pour adapter les ateliers et mesurer leurs effets.

Mise en situation – MSE 3

Le jury : « Votre échantillon de 48 parents est-il représentatif ? »

Corrigé

Non, c'est un échantillon de convenance (sortie d'école et épicerie), avec un biais de sélection possible ; la marge d'erreur théorique est d'environ ± 13 points. J'ai donc croisé ces résultats avec des entretiens, un groupe de parole et les données du quartier ; les tendances concordent, ce qui renforce le diagnostic.

Mise en situation – MSE 4

Le jury : « Pourquoi avez-vous choisi ce problème et pas un autre ? »

Corrigé

J'ai utilisé des critères explicites : ampleur, gravité, efficacité des interventions et faisabilité (méthode de Hanlon et test PEARL) ; le problème choisi a obtenu le score le plus élevé et correspond à la demande des habitants et aux priorités du CLS ; les autres problèmes ont donné lieu à une orientation ou à un plaidoyer.

Mise en situation – MSE 5

Un partenaire affirme : « Les gens du quartier mangent mal, c'est un fait. »

Corrigé

Je propose de vérifier par des données (questionnaire, observation) et d'écouter les habitants ; j'évite les généralisations et je rappelle les déterminants (budget, offre, temps) plutôt qu'un jugement sur les personnes.

Mise en situation – MSE 6

Le jury : « Qu'est-ce qu'un besoin normatif ? Donnez un exemple tiré de votre stage. »

Corrigé

C'est un besoin défini par les experts en comparant la situation à une norme : par exemple, seulement 27 % des familles atteignent le repère « légumes secs au moins 2 fois par semaine » du PNNS.

Mise en situation – MSE 7

Vous constatez qu'une question de votre questionnaire n'a pas été comprise (40 % de non-réponses).

Corrigé

Je ne l'exploite pas ou avec prudence, je le signale dans les limites, je la reformule (et la teste) pour l'évaluation finale ; c'est un apprentissage à présenter au jury (importance du prétest).

Mise en situation – MSE 8

Le jury : « Que signifie SMART ? »

Corrigé

Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste (pertinent), temporellement défini ; j'illustre avec un objectif de mon projet en montrant chaque critère.

Mise en situation – MSE 9

Le jury : « Votre résultat est passé de 25 % à 60 % : c'est une hausse de combien ? »

Corrigé

De 35 points de pourcentage, soit une hausse relative de 140 % ((60 − 25) / 25 × 100) ; avec 12 familles, cela représente de 3 à 7 ou 8 familles, à interpréter avec prudence.

Mise en situation – MSE 10

Le jury : « Où avez-vous trouvé vos données de santé locales ? »

Corrigé

Dans le diagnostic local de santé du CLS réalisé par l'ORS, sur Géodes (Santé publique France) et auprès du service de santé scolaire (données agrégées), avec leurs dates ; les données nationales viennent d'Esteban et d'INCA 3.

Mise en situation – MSE 11

Un habitant demande pourquoi vous posez « toutes ces questions ».

Corrigé

J'explique simplement l'objectif (construire des ateliers qui correspondent à leurs besoins), l'anonymat, le caractère facultatif et l'usage des réponses ; je le remercie et je lui propose de participer au groupe de parole.

Mise en situation – MSE 12

Le jury : « Qu'est-ce qu'un arbre à problèmes et à quoi sert-il ? »

Corrigé

C'est une représentation du problème central, de ses causes (racines) et de ses conséquences (branches), chaque cause étant étayée par un fait ; il sert à choisir les causes sur lesquelles agir et se transforme en arbre à objectifs.

7.8.6 Exercices complémentaires

À vous de jouer – Exercice 11 – Schéma à légender : les méthodes d'échantillonnage

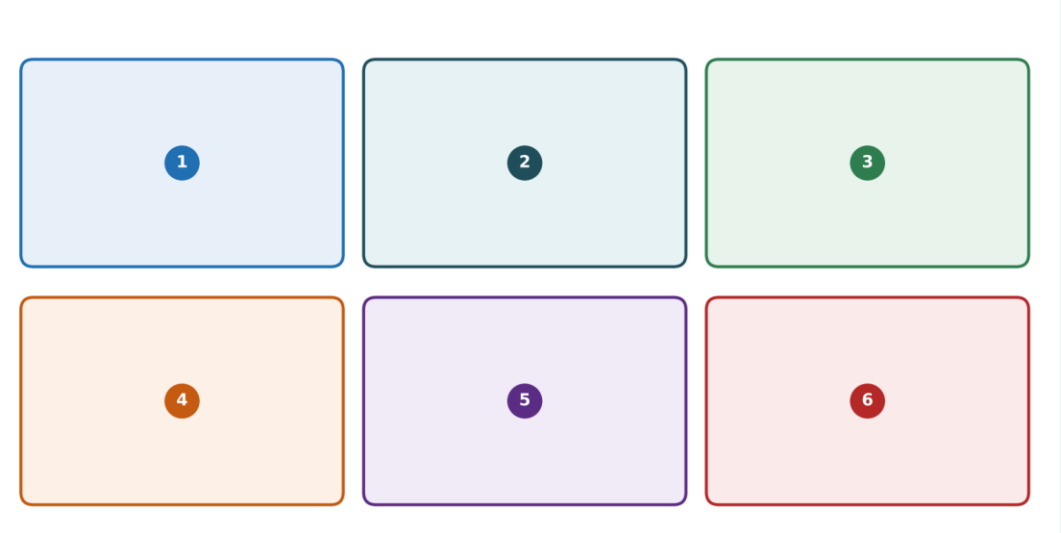


Figure 7.15 – Schéma à légender

Nommez les méthodes 1 à 6 et indiquez laquelle a été utilisée dans chaque cas : a) on interroge les parents présents à la sortie de l'école ; b) on tire au sort 10 classes et on interroge tous leurs élèves ; c) on interroge un salarié sur 5 de la liste du personnel ; d) on tire au sort 20 élèves par niveau, proportionnellement aux effectifs.

Corrigé

1. Aléatoire simple. 2. Systématique. 3. Stratifié. 4. Par grappes. 5. Par quotas. 6. De convenance. a) **convenance** ; b) **grappes** ; c) **systématique** (pas de 5) ; d) **stratifié**.

À vous de jouer – Exercice 12 – Construire un échantillon stratifié

Une épicerie solidaire compte 240 foyers : 96 familles avec enfants, 84 personnes seules, 60 retraités. On veut interroger 60 foyers proportionnellement. Calculez les effectifs par strate et le pas de sondage dans chaque liste.

Corrigé

Taux : 60 / 240 = **0,25**. Familles : 96 × 0,25 = **24** ; personnes seules : 84 × 0,25 = **21** ; retraités : 60 × 0,25 = **15** ; total **60**. Pas de sondage : 96 / 24 = **4** ; 84 / 21 = **4** ; 60 / 15 = **4** (un foyer sur 4 dans chaque liste, à partir d'un point de départ tiré au hasard entre 1 et 4).

À vous de jouer – Exercice 13 – Groupe nominal

Dix professionnels votent (5-4-3-2-1 points) sur les priorités nutritionnelles d'une commune. Totaux : dénutrition des seniors 38 ; restauration scolaire 34 ; précarité alimentaire 41 ; sédentarité des jeunes 22 ; obésité adulte 15. Vérifiez le total, classez et calculez la part des trois premières priorités.

Corrigé

Total attendu : 10 × 15 = **150** ; observé : 38 + 34 + 41 + 22 + 15 = **150**. Classement : précarité alimentaire (41) > dénutrition des seniors (38) > restauration scolaire (34) > sédentarité (22) > obésité adulte (15). Trois premières : (41 + 38 + 34) / 150 × 100 = 113 / 150 × 100 = **75,3 %**. À croiser avec la méthode de Hanlon et les données.

À vous de jouer – Exercice 14 – Indice d'environnement alimentaire

Autour d'un lycée (rayon de 500 m) : 1 supermarché, 1 primeur, 1 marché hebdomadaire, 5 restaurants rapides, 2 boulangeries-snacking, 1 distributeur automatique dans le hall. Calculez l'indice d'environnement favorable (on compte la boulangerie comme défavorable si elle vend surtout du snacking) et interprétez.

Corrigé

Favorables : 1 + 1 + 1 = **3** ; défavorables : 5 + 2 + 1 = **8** ; indice : 3 / (3 + 8) × 100 = 3 / 11 × 100 = **27,3**. Environnement dominé par l'offre défavorable (marais alimentaire) : leviers : offre du self et du foyer des élèves, distributeur reconverti (eau, fruits, produits laitiers), plaidoyer, éducation à la critique du marketing.

À vous de jouer – Exercice 15 – Tableau croisé

Enquête auprès de 120 collégiens : petit-déjeuner quotidien chez 42 des 70 élèves dont les deux parents travaillent tôt (avant 7 h) et chez 38 des 50 autres. Construisez le tableau croisé, calculez les pourcentages pertinents et interprétez.

Corrigé

Tableau : parents tôt : 42 oui, 28 non (70) ; autres : 38 oui, 12 non (50) ; total : 80 oui, 40 non (120). Pourcentages en ligne : parents tôt : 42 / 70 = **60,0 %** ; autres : 38 / 50 = **76,0 %** ; ensemble : 80 / 120 = **66,7 %**. Écart : **16 points**. Les horaires parentaux semblent liés au saut du petit-déjeuner : piste d'action (petit-déjeuner préparé la veille, collation à l'arrivée au collège), à confirmer (effectifs modestes).

À vous de jouer – Exercice 16 – Formuler une problématique

Diagnostic dans un foyer de jeunes travailleurs : 62 % des jeunes sautent au moins un repas par jour ; les cuisines collectives sont peu utilisées (« sales », « pas d'ustensiles ») ; les jeunes disent ne pas savoir cuisiner ; 70 % utilisent des plateformes de livraison au moins une fois par semaine. Rédigez la problématique, le problème central et l'objectif général.

Corrigé

Problème central : « Près des deux tiers des jeunes du foyer sautent au moins un repas par jour. » **Problématique** : « Comment permettre aux jeunes du foyer, qui ne savent pas cuisiner et n'utilisent pas les cuisines collectives, de préparer des repas simples, économiques et conviviaux plutôt que de sauter des repas ou de recourir à la livraison ? » **Objectif général** : « Contribuer à améliorer la régularité et l'équilibre de l'alimentation des jeunes du foyer. »

À vous de jouer – Exercice 17 – FFOM croisée

À partir de l'analyse FFOM d'un club sportif (forces : entraîneurs motivés, salle de réunion ; faiblesses : aucun budget, pas de cuisine ; opportunités : mutuelle partenaire, appel à projets « sport-santé » ; menaces : boissons énergisantes très présentes, départ d'entraîneurs), proposez une stratégie pour chaque case.

Corrigé

F × O : former les entraîneurs avec l'appui de la mutuelle et répondre à l'appel à projets. Fa × O : financer des collations et un réfrigérateur grâce à l'appel à projets. F × M : faire des entraîneurs des relais contre les boissons énergisantes. Fa × M : outils simples réutilisables (affiches, fiches collations) pour pérenniser malgré les départs.

À vous de jouer – Exercice 18 – Quotas

Population d'un quartier : 54 % de femmes ; moins de 25 ans 31 %, 25-64 ans 51 %, 65 ans ou plus 18 %. Calculez les quotas pour 150 questionnaires.

Corrigé

Femmes : 0,54 × 150 = **81** ; hommes : **69**. Moins de 25 ans : 0,31 × 150 = **46,5**, soit **47** ; 25-64 ans : 0,51 × 150 = **76,5**, soit **76** ; 65 ans ou plus : 0,18 × 150 = **27** ; total 47 + 76 + 27 = **150** (arrondis ajustés pour respecter le total ; vérifié).

7.9 Glossaire

Terme	Définition
Analyse de situation	Collecte et organisation des informations sur un territoire, une population, ses problèmes, ressources et politiques
Arbre à objectifs	Transformation positive de l'arbre à problèmes en hiérarchie d'objectifs
Arbre à problèmes	Représentation du problème central, de ses causes et de ses conséquences
Besoin comparatif	Écart entre une population et une population de référence
Besoin exprimé	Besoin ressenti traduit en demande
Besoin normatif	Besoin défini par des experts par rapport à une norme
Besoin ressenti	Manque perçu par les personnes
Biais de sélection	Échantillon différent de la population visée
Cadre logique	Matrice reliant objectifs, résultats, activités, indicateurs, sources et hypothèses

Terme	Définition
CLS	Contrat local de santé entre l'ARS et une collectivité (art. L. 1434-10 CSP)
Diagnostic	Interprétation des données identifiant et hiérarchisant les problèmes et besoins
FFOM (SWOT)	Forces, faiblesses (internes), opportunités, menaces (externes)
Groupe de parole (focus group)	Discussion animée de 6 à 10 personnes sur un thème
Hanlon (méthode de)	Priorisation par le score (A + 2B) × C / 3 et le test PEARL
Marge d'erreur	Demi-largeur de l'intervalle de confiance d'une estimation
Objectif général	But à long terme auquel le projet contribue
Objectif opérationnel	Réalisation de l'équipe, SMART
Objectif spécifique	Changement attendu chez le public, SMART
Prétest	Test d'un questionnaire auprès de quelques personnes avant passation
Problème central	Situation négative, observable et mesurable, au cœur du diagnostic
SMART	Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini
Triangulation	Croisement de plusieurs sources et méthodes
Base de sondage	Liste complète de la population dans laquelle on tire l'échantillon
Désert alimentaire	Territoire où l'accès à des produits frais et abordables est difficile
Échantillon stratifié	Échantillon tiré dans chaque sous-groupe (strate) selon son poids
FFOM croisée (TOWS)	Matrice transformant forces, faiblesses, opportunités et menaces en stratégies
Groupe nominal	Technique de priorisation en groupe : réflexion individuelle, tour de table, vote
Marais alimentaire	Territoire où l'offre défavorable à la santé domine l'offre favorable
Pas de sondage	Intervalle k = N / n entre deux personnes tirées dans un tirage systématique
Photovoice	Méthode participative où les habitants photographient et commentent leur environnement
Problématique	Question ouverte reliant le diagnostic au projet
Quotas	Répartition imposée d'un échantillon selon des caractéristiques connues de la population

7.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Démarche de projet	[1] Pineault et Daveluy ; [2] Green et Kreuter ; [3] INPES guide d'autoévaluation ; [4] Promotion Santé Suisse
Besoins	[5] Bradshaw
Sources de données	[6] Géodes ; [7] Insee ; [8] ANSES INCA 3 ; [9] Santé publique France Esteban
Méthodes d'enquête	[10] de Singly ; [11] Kaufmann
Priorités	[12] NACCHO (Hanlon)
Objectifs	[13] Anderson et Krathwohl (Bloom révisée)
CLS, interventions probantes	[14] CSP L. 1434-10 ; [15] Santé publique France, portail des interventions

7.12 Bibliographie numérotée

1. Pineault R., Daveluy C. *La planification de la santé : concepts, méthodes, stratégies*. Montréal, Éditions Nouvelles, 1995.

2. Green L. W., Kreuter M. W. *Health Program Planning: An Educational and Ecological Approach*. McGraw-Hill, 4e éd., 2005.

3. INPES. *Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion de la santé ? Guide d'autoévaluation construit par et pour des associations*. Saint-Denis, 2009.

4. Promotion Santé Suisse. *Outil de catégorisation des résultats de projets de promotion de la santé et de prévention*. Adaptation française diffusée par Santé publique France.

5. Bradshaw J. « The concept of social need ». *New Society*, 1972, 496, p. 640-643.

6. Santé publique France. *Géodes, observatoire cartographique des indicateurs épidémiologiques*, *geodes.santepubliquefrance.fr*.

7. Insee. Recensement de la population ; dispositif Filosofi ; *insee.fr*.

8. ANSES. *Étude individuelle nationale des consommations alimentaires 3 (INCA 3)*. Avis et rapport, juin 2017.

9. Santé publique France. *Étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition (Esteban) 2014-2016*, volet nutrition. 2017.

10. de Singly F. *L'enquête et ses méthodes : le questionnaire*. Paris, Armand Colin, 4e éd., 2020.

11. Kaufmann J.-C. *L'entretien compréhensif*. Paris, Armand Colin, 4e éd., 2016.

12. NACCHO (National Association of County and City Health Officials). *Guide to Prioritization Techniques* (méthode de Hanlon). Washington.

13. Anderson L. W., Krathwohl D. R. (dir.). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Longman, 2001.

14. Code de la santé publique, article L. 1434-10 (contrats locaux de santé).

15. Santé publique France. *Répertoire des interventions efficaces ou prometteuses en prévention et promotion de la santé*, *santepubliquefrance.fr*.

16. Delbecq A. L., Van de Ven A. H. « A group process model for problem identification and program planning ». *Journal of Applied Behavioral Science*, 1971, 7 (4), p. 466-492.

17. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). *Census tract level state maps of the modified Retail Food Environment Index (mRFEI)*. Atlanta, 2011.

18. Wang C., Burris M. A. « Photovoice: concept, methodology, and use for participatory needs assessment ». *Health Education & Behavior*, 1997, 24 (3), p. 369-387.

19. Ardilly P. *Les techniques de sondage*. Paris, Technip, 2e éd., 2006.

20. Insee. Base permanente des équipements (BPE), *insee.fr*.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 7.2.2)

21. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE

CHAPITRE

07

Démarche de projet (1) : diagnostic, priorités et objectifs

Démarche de projet (1) | Analyse de situation | Diagnostic | Priorités | Objectifs

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

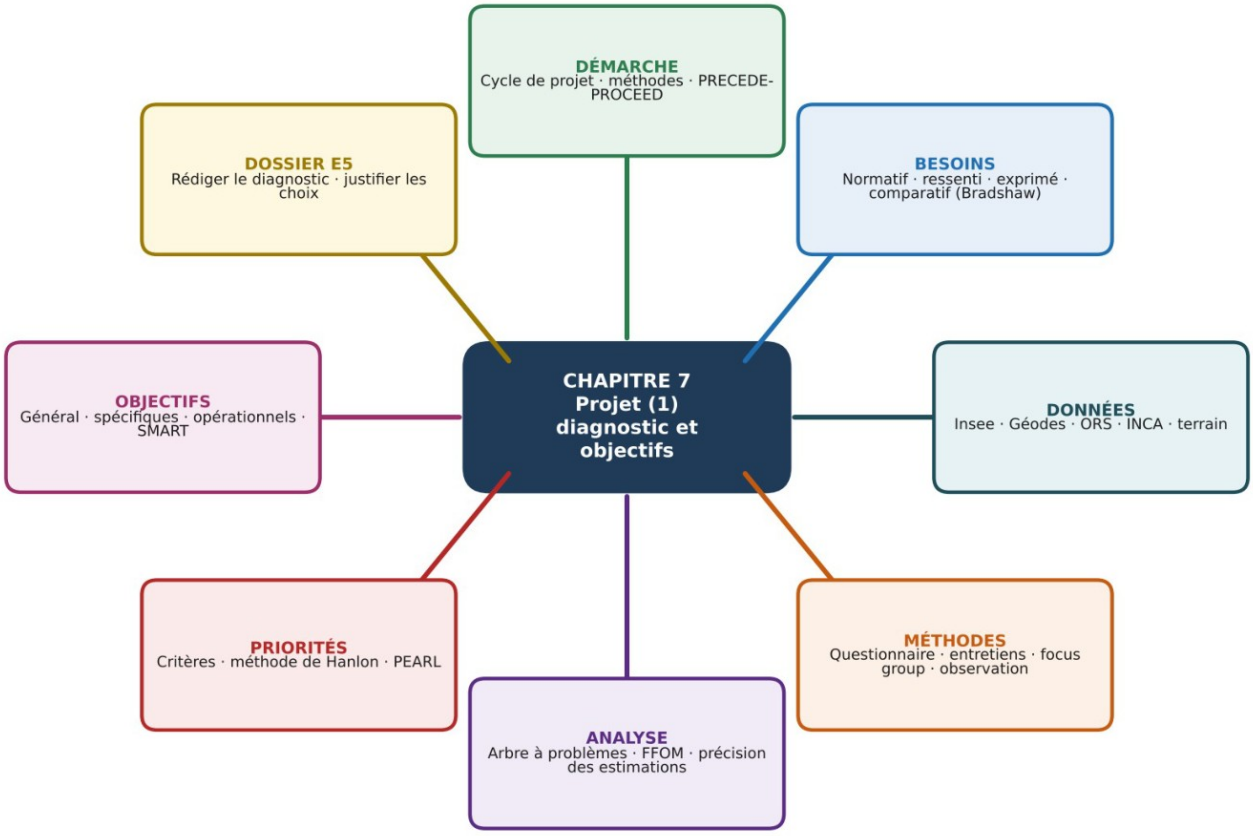
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 7 100
1. Le cycle de projet 100
2. Les définitions à savoir 100
3. Les formules 101
4. Le questionnaire en 8 étapes 101
5. Les pièges 101
6. Auto-test 101
7. Flashcards 101
Compléments du chapitre enrichi 102

Fiches-outils du chapitre 7 102
O7.1 – Grille d'analyse de situation 102
O7.2 – Guide d'entretien semi-directif (professionnel) 102
O7.3 – Grille de prétest d'un questionnaire 103
O7.4 – Grille de priorisation (Hanlon + PEARL) 103
O7.5 – Grille de vérification des objectifs SMART 103
O7.6 – Calculateur de précision (à la main) 103

Fiche de révision du chapitre 7

Démarche de projet (1) : diagnostic, priorités, objectifs



Carte mentale du chapitre 7

1. Le cycle de projet

Analyse de situation (F1) → diagnostic et priorités (F2) → objectifs (F3) → plan d'action (F4-F6) → mise en œuvre (F7-F10) → évaluation (F11-F12) → valorisation (F13-F14), avec au centre la participation, le partenariat et l'éthique.

2. Les définitions à savoir

Notion	Définition
Besoins (Bradshaw, 1972)	Normatif (experts) · ressenti (perçu) · exprimé (demande) · comparatif (écart)
Problème central	Situation négative, observable, mesurable — jamais une absence de solution
Arbre à problèmes	Causes (avec faits) → problème → conséquences
FFOM	Forces / faiblesses (internes) ; opportunités / menaces (externes)
Objectif spécifique	Changement chez le public, SMART
Objectif opérationnel	Ce que fait l'équipe, SMART
Triangulation	Croiser sources et méthodes

3. Les formules

Calcul	Formule et exemple
Pourcentage	n / total × 100 : 34 / 48 = 70,8 %
Écart en points / rapport	14 − 9 = 5 points ; 14 / 9 = 1,56
Variation relative	(final − initial) / initial × 100 : (60 − 25) / 25 = + 140 %
Marge d'erreur	1,96 × √(p(1 − p)/n) : 48 parents, p = 0,708 → ± 12,9 points
Taille d'échantillon	$1{,}96^2 \times p(1-p)/e^2$: ± 5 points → 385
Hanlon	(A + 2B) × C / 3 + test PEARL : (7 + 12) × 7 / 3 = 44,3
Valeur cible	% × effectif, arrondi au supérieur : 0,60 × 12 = 7,2 → 8

4. Le questionnaire en 8 étapes

Objectif → variables → types de questions → rédaction (une idée, pas d'orientation, modalités exhaustives et exclusives, période courte) → ordre → mention RGPD → prétest → grille d'analyse.

5. Les pièges

Attention

- Commencer par l'action.
- Écrire « + 35 % » pour un passage de 25 % à 60 % (c'est + 35 points).
- Donner des pourcentages sans effectifs sur de petits groupes.
- Confondre objectif opérationnel (« animer 6 ateliers ») et objectif spécifique.
- Utiliser des verbes non observables (« sensibiliser », « prendre conscience »).
- Citer un chiffre sans source ni date.

6. Auto-test

1. Les 4 besoins de Bradshaw ? 2. Formule de Hanlon ? 3. Que signifie PEARL ? 4. Taille d'échantillon pour ± 10 points ? 5. Différence écart et rapport ? 6. Trois biais ? 7. FFOM : qu'est-ce qui est externe ? 8. Les 3 niveaux d'objectifs ? 9. Facteurs de PRECEDE ? 10. Qui signe un CLS ? *Réponses : 1. Normatif, ressenti, exprimé, comparatif – 2. (A + 2B) × C / 3 – 3. Pertinence, économie, acceptabilité, ressources, légalité – 4. 97 – 5. Soustraction (points) / division (fois plus) – 6. Sélection, désirabilité sociale, mémoire (non-réponse, enquêteur) – 7. Opportunités et menaces – 8. Général, spécifiques, opérationnels – 9. Prédisposants, facilitants, de renforcement – 10. L'ARS et une collectivité.*

7. Flashcards

Recto : Diagnostic partagé ?	Verso : Construit avec habitants et partenaires
Recto : Photovoice ?	Verso : Les habitants photographient et commentent leur environnement
Recto : Correction population finie ?	Verso : n' = n / (1 + (n − 1)/N)
Recto : Cadre logique ?	Verso : Objectifs, indicateurs, sources de vérification, hypothèses
Recto : Théorie du changement ?	Verso : Chaîne « si… alors… » entre activités et effets
Recto : Plan de la partie diagnostic ?	Verso : Structure, contexte, méthode, résultats, synthèse, objectifs

Compléments du chapitre enrichi

Notion	À retenir
Échantillonnage	Aléatoire simple, systématique (pas k = N/n), stratifié, grappes, quotas, convenance ; correction population finie n' = n / (1 + (n − 1)/N)
Participation	Photolangage, photovoice, marche exploratoire, cartographie, world café ; groupe nominal (5-4-3-2-1 ; total = participants × 15)
Environnement	Indice favorable / (favorable + défavorable) × 100 ; densité pour 1 000 hab. ; désert / marais alimentaire
Tableaux croisés	% dans le sens des groupes comparés ; khi-deux (L3) : seuil 3,84 pour 1 ddl
Problématique	Constat → tension → public, lieu, levier → « Comment… ? » ; cohérence avec problème central et objectif général
FFOM croisée	Offensive (F × O), amélioration (Fa × O), défensive (F × M), survie (Fa × M)

Fiches-outils du chapitre 7

Outil	Intitulé	Utilité
O7.1	Grille d'analyse de situation	Organiser les données par rubrique, avec sources
O7.2	Guide d'entretien semi-directif (professionnel)	Recueillir les besoins ressentis par les partenaires
O7.3	Grille de prétest d'un questionnaire	Vérifier compréhension et durée
O7.4	Grille de priorisation (Hanlon + PEARL)	Choisir le problème à traiter
O7.5	Grille de vérification des objectifs SMART	Contrôler chaque objectif
O7.6	Calculateur de précision (à la main)	Marge d'erreur et taille d'échantillon

O7.1 – Grille d'analyse de situation

Rubrique	Données (chiffre, comparaison)	Source et date	Type de besoin
Territoire			
Population			
État de santé			
Comportements alimentaires			
Offre et environnement			
Ressources et acteurs			
Politiques et financements			
Besoins exprimés (habitants)			
Besoins ressentis (professionnels)			
Besoins observés			

O7.2 – Guide d'entretien semi-directif (professionnel)

Thème	Questions de relance
Présentation	« Pouvez-vous me présenter votre rôle auprès des familles ? »

Thème	Questions de relance
Constats	« Que constatez-vous sur l'alimentation des personnes que vous accompagnez ? » « Avez- vous des exemples ? »
Causes	« Selon vous, qu'est-ce qui explique ces difficultés ? »
Ressources	« Qu'est-ce qui existe déjà ? Qu'est-ce qui marche ? »
Attentes	« Quel type d'action vous semblerait utile ? Pour qui ? »
Partenariat	« Comment pourriez-vous y participer (orientation, locaux, communication) ? »
Contraintes	« Quels obstacles prévoir (horaires, langues, transports) ? »
Clôture	« Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Puis-je vous recontacter ? »

Durée : 30 minutes ; prise de notes ou enregistrement avec accord ; compte rendu anonymisé.

O7.3 – Grille de prétest d'un questionnaire

N°	Question non comprise ou hésitation	Modalité manquante	Correction apportée
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Durée moyenne de passation : ..... min. Nombre de personnes testées : .....

O7.4 – Grille de priorisation (Hanlon + PEARL)

Problème	A	B	C	(A + 2B) × C / 3	P	E	A	R	L	Ra ng

A = ampleur, B = gravité, C = efficacité (0 à 10) ; PEARL : 1 = oui, 0 = non (un 0 écarte le problème).

Justification des notes et décision :

O7.5 – Grille de vérification des objectifs SMART

Objectif	S	M	A	R	T	Indicateur et valeur initiale
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	

O7.6 – Calculateur de précision (à la main)

Étape	Mon enquête	Exemple (34/48)
p = effectif / n		0,708
1 − p		0,292

Étape	Mon enquête	Exemple (34/48)
p × (1 − p)		0,2067
÷ n		0,004307
√		0,0656
× 1,96 = marge e		0,129 (± 12,9 points)
Intervalle [p − e ; p + e]		57,9 % – 83,7 %

Taille d'échantillon : n = 3,8416 × p(1 − p) / e² ; ± 5 points → 385 ; ± 8 → 151 ; ± 10 → 97.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES

CHAPITRE

07

Démarche de projet (1) : diagnostic, priorités et objectifs

Démarche de projet (1) | Analyse de situation | Diagnostic | Priorités | Objectifs

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 7 108
Mode d'emploi du cahier 108
Partie 1 – Le projet et l'analyse de situation 110
Exercice 7.1 – Le cycle de projet (10 points) 111
Exercice 7.2 – Classer les informations d'une analyse de situation (10 points) 113
Exercice 7.3 – Citer une donnée et choisir une source (10 points) 115
Exercice 7.4 – Comparer un territoire à sa référence (12 points) 117
Exercice 7.5 – Repérer les acteurs et les ressources (12 points) 119
Exercice 7.6 – Rédiger une analyse de situation (16 points) 121
Corrigés de la partie 1 123
Partie 2 – Recueillir les données sur le terrain 126
Exercice 7.7 – Quelle méthode pour quelle question ? (10 points) 127
Exercice 7.8 – Corriger un questionnaire mal rédigé (10 points) 129
Exercice 7.9 – Construire un questionnaire en huit étapes (12 points) 131
Exercice 7.10 – Préparer et conduire un entretien semi-directif (12 points) 133
Exercice 7.11 – Relevé de prix et accès à l'offre (12 points) 135
Exercice 7.12 – Biais et exploitation d'un prétest (16 points) 137
Corrigés de la partie 2 139
Partie 3 – Analyser et présenter les données 142
Exercice 7.13 – Points ou pour cent ? (10 points) 143
Exercice 7.14 – Moyenne ou médiane ? (10 points) 144
Exercice 7.15 – Choisir et critiquer un graphique (10 points) 145
Exercice 7.16 – Lire un tableau croisé (12 points) 147
Exercice 7.17 – Risque relatif et intervalle de confiance (14 points) 149
Exercice 7.18 – Rédiger les résultats d'une petite enquête (16 points) 151
Corrigés de la partie 3 153
Partie 4 – Échantillonnage et précision 155
Exercice 7.19 – Les méthodes d'échantillonnage (10 points) 156
Exercice 7.20 – Un échantillon stratifié dans un lycée professionnel (10 points) 158
Exercice 7.21 – Tirage systématique et quotas (10 points) 160
Exercice 7.22 – Marge d'erreur et intervalle de confiance (12 points) 161
Exercice 7.23 – Calculer une taille d'échantillon (12 points) 162
Exercice 7.24 – Choisir une stratégie d'échantillonnage réaliste (16 points) 163
Corrigés de la partie 4 165
Partie 5 – Poser le diagnostic 167
Exercice 7.25 – Les quatre types de besoins (10 points) 168
Exercice 7.26 – Construire un arbre à problèmes (12 points) 170
Exercice 7.27 – Mesurer l'environnement alimentaire d'un quartier (12 points) 172
Exercice 7.28 – Quand les sources se contredisent (12 points) 174
Exercice 7.29 – Mesurer les inégalités sociales (12 points) 175
Exercice 7.30 – Rédiger le diagnostic d'un chantier d'insertion (16 points) 176
Corrigés de la partie 5 178
Partie 6 – Définir les priorités 181
Exercice 7.31 – Les critères de priorité (10 points) 182
Exercice 7.32 – Calculer des scores de Hanlon (12 points) 183
Exercice 7.33 – Le test PEARL et la décision (12 points) 185
Exercice 7.34 – Dépouiller un groupe nominal (12 points) 186
Exercice 7.35 – Choisir une méthode participative (12 points) 188

Exercice 7.36 – Arbitrer en comité de pilotage avec la matrice FFOM croisée (16 points) 190
Corrigés de la partie 6 192
Partie 7 – Problématique et objectifs 195
Exercice 7.37 – La hiérarchie des objectifs (10 points) 196
Exercice 7.38 – Rendre un objectif SMART (12 points) 198
Exercice 7.39 – Calculer des valeurs cibles (10 points) 199
Exercice 7.40 – De l'arbre à problèmes à l'arbre à objectifs (12 points) 200
Exercice 7.41 – Formuler une problématique (12 points) 201
Exercice 7.42 – Construire le cadre logique d'un projet (16 points) 202
Corrigés de la partie 7 203
Partie 8 – Synthèse : diagnostic en situation réelle et cas complet 206
Exercice 7.43 – Diagnostic local de santé et contrat local de santé (10 points) 207
Exercice 7.44 – Un diagnostic en milieu scolaire (12 points) 208
Exercice 7.45 – Un diagnostic en entreprise (12 points) 209
Exercice 7.46 – Relire la partie « diagnostic » d'un dossier (12 points) 210
Exercice 7.47 – Défendre son diagnostic devant le jury (14 points) 211
Exercice 7.48 – Cas complet : les repas des auxiliaires de vie « sur la route » (40 points) 213
Corrigés de la partie 8 217
Bilan : grille d'auto-évaluation 221

Cahier d'exercices – Chapitre 7

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 7 : cycle de projet, analyse de situation, sources de données, recueil sur le terrain (questionnaire, entretien, observation), analyse et présentation des données, échantillonnage et précision, besoins selon Bradshaw, arbre à problèmes, environnement alimentaire, inégalités, priorités (critères, méthode de Hanlon, test PEARL, groupe nominal), problématique, matrice FFOM croisée, hiérarchie des objectifs et objectifs SMART (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition », C3.3 « Participer à des activités de recherche appliquée en nutrition humaine » et C3.4 « Assurer une veille scientifique, professionnelle et réglementaire » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : le cycle de projet, les rubriques d'une analyse de situation, le choix d'une méthode de recueil, le questionnaire en huit étapes, le choix d'un graphique, les méthodes d'échantillonnage, l'arbre à problèmes, les besoins de Bradshaw, le score de Hanlon et le test PEARL, la hiérarchie des objectifs, la matrice FFOM croisée.
- Calculer et interpréter : pourcentages, écarts en points et variations relatives, moyenne et médiane, pourcentages en ligne et en colonne, risque relatif et intervalle de confiance, marge d'erreur, taille d'échantillon et correction pour population finie, répartition stratifiée, scores de priorité, valeurs cibles, coût et apports d'un repas (Ciqual 2025).
- Rédiger les parties « analyse de situation », « diagnostic », « priorités » et « objectifs » d'un dossier de projet, et les défendre à l'oral.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits d'entretiens), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, communes, personnes, prix et chiffres des enquêtes locales sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025). Les textes officiels, les auteurs et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Traiter une question de diagnostic à l'examen

Pour chaque question, suivez quatre temps. D'abord, relevez les faits utiles dans les documents, avec leur source et leur date. Ensuite, faites les calculs en posant la formule, l'application numérique et le résultat avec son unité (pourcentage, points, rapport). Puis interprétez avec prudence : effectifs, biais possibles,

comparaison avec une référence. Enfin, concluez par une phrase qui sert le projet (un besoin, une priorité, un objectif). Une copie qui donne un chiffre sans l'interpréter, ou une conclusion sans chiffre, perd des points.

Partie 1 – Le projet et l'analyse de situation

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir un projet de santé publique et situer chaque étape du cycle de projet.
- Distinguer analyse de situation et diagnostic.
- Classer des informations dans les rubriques d'une analyse de situation et choisir les sources adaptées.
- Citer une donnée avec sa source, son année et son champ.
- Comparer un territoire à une référence (pourcentage, écart en points, rapport).
- Repérer les acteurs et les ressources d'un territoire.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Projet de santé publique : ensemble d'actions coordonnées, limité dans le temps, conduit avec et pour une population, pour répondre à un problème de santé ou à un déterminant identifié par un diagnostic, avec des objectifs, des moyens et une évaluation.
- Cycle de projet : analyse de situation → diagnostic et priorités → objectifs → plan d'action → mise en œuvre → évaluation → valorisation et ajustements ; au centre : participation, partenariat, éthique.
- Analyse de situation (état des lieux) : collecte et organisation des informations sur le territoire, la population, la santé, les comportements, l'offre, les acteurs, les politiques et les attentes. Diagnostic : interprétation de ces informations (problèmes, besoins, causes, ressources).
- Huit rubriques : territoire, population, état de santé, comportements, offre et environnement, ressources et acteurs, politiques et financements, besoins et attentes.
- Toute donnée est citée avec sa source, son année (ou période de recueil) et son champ (âge, territoire).
- Écart en points : différence de deux pourcentages ; rapport : quotient de deux pourcentages.

Exercice 7.1 – Le cycle de projet (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous commencez votre stage de santé publique dans le service prévention d'une mutuelle (structure fictive). Votre tutrice vous demande de présenter à l'équipe, en cinq minutes, la démarche que vous allez suivre pour construire un projet.

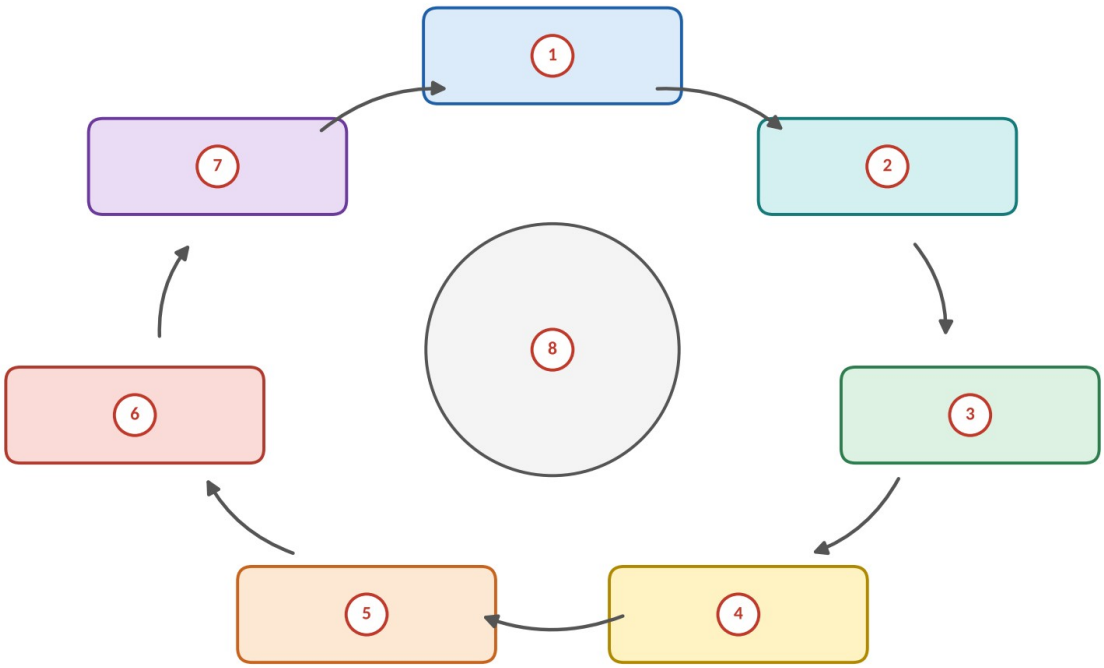


Figure 7.1 – Document 1 – Le cycle de projet en santé publique (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Définissez un projet de santé publique en une phrase qui contient au moins quatre caractéristiques. (2 pts)
3. Distinguez l'analyse de situation et le diagnostic. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi le cycle est représenté par une boucle et non par une ligne droite. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

……

……

……

……

Exercice 7.2 – Classer les informations d'une analyse de situation (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

La communauté de communes du Haut-Rivalet (fictive) souhaite un projet sur l'alimentation des familles. Votre tutrice vous transmet en vrac les informations déjà réunies et vous demande de les ranger.

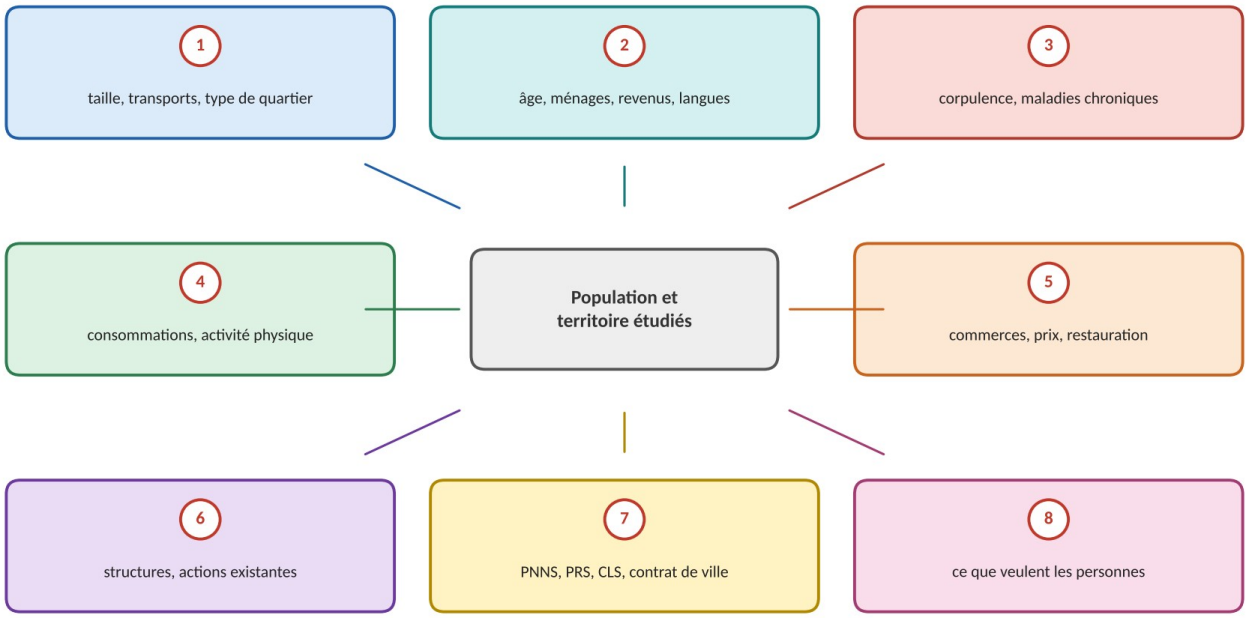


Figure 7.2 – Document 1 – Les rubriques d'une analyse de situation (schéma à légender)

Document 2 – Douze informations réunies

a) 18 600 habitants répartis dans 14 communes ; la plus éloignée est à 27 km du supermarché le plus proche.

b) 31 % des ménages ont au moins un enfant de moins de 18 ans.

c) Le service de santé scolaire relève 12 % d'enfants de grande section en surpoids, obésité comprise.

d) Une enquête du centre social indique que 40 % des parents ne servent jamais de légumes secs.

e) Deux marchés hebdomadaires, une épicerie solidaire, onze boulangeries et quatre supérettes.

f) Le centre social, la PMI, deux médecins généralistes, une association de jardins familiaux.

g) Un contrat local de santé est en préparation ; le projet alimentaire territorial a été signé.

h) Lors d'une réunion, des parents demandent « des idées de repas rapides et pas chers ».

i) La ligne de bus relie le bourg à la ville-centre trois fois par jour.

j) Le revenu médian est inférieur à celui du département.

k) La moitié des enfants de l'école du bourg déjeunent à la cantine.

l) La commune finance un appel à projets « bien manger » de 3 000 €.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les rubriques numérotées 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Classez les douze informations du document 2 dans ces rubriques. Une information peut relever de deux rubriques : justifiez alors votre choix. (4 pts)
3. Repérez deux informations du document 2 qui ne sont pas citées correctement et dites ce qui leur manque. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.3 – Citer une donnée et choisir une source (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous relisez le brouillon du dossier de projet d'une autre étudiante. Votre tutrice a souligné cinq phrases en écrivant dans la marge : « D'où vient ce chiffre ? »

Document 1 – Cinq phrases du brouillon

a) « Beaucoup d'enfants sont en surpoids dans le quartier. »

b) « 17 % des adultes sont obèses. »

c) « Les habitants sont pauvres. »

d) « D'après Internet, les jeunes ne mangent plus de légumes. »

e) « Il y a de plus en plus de diabète. »

Document 2 – Sources disponibles

Insee (recensement, Filosofi) ; Géodes (Santé publique France) ; Esteban (Santé publique France, 2014-2016) ; INCA 3 (ANSES, 2014-2015) ; service de santé scolaire ; Data pathologies (Assurance maladie) ; CAF ; enquête menée par la structure.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque phrase du document 1, dites ce qui ne va pas. (2,5 pts)
2. Proposez la source la plus adaptée pour chaque phrase, en vous aidant du document 2, et réécrivez la phrase sous une forme correcte (vous pouvez laisser les chiffres en pointillés si vous ne les connaissez pas). (5 pts)
3. Énoncez la règle de citation d'une donnée dans un diagnostic. (1,5 pt)
4. Expliquez pourquoi on ne peut pas utiliser une moyenne nationale à la place d'une donnée locale sans le dire. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.4 – Comparer un territoire à sa référence (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La ville de Brévannes-sur-Loir (fictive, 12 400 habitants) veut savoir si elle se distingue du département sur quelques indicateurs. Vous disposez des effectifs de la commune et des pourcentages départementaux.

Document 1 – Quatre indicateurs (données fictives, année 2026)

Indicateur	Commune : effectif	Commune : total de référence	Département
Personnes de 60 ans et plus	3 410	12 400 habitants	26,0 %
Familles monoparentales	412	1 830 familles avec enfants	22,0 %
Ménages à bas revenus	1 260	5 150 ménages	15,0 %
Enfants de grande section en surpoids, obésité comprise	23	148 enfants examinés	9,0 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de chaque indicateur dans la commune, au dixième. (4 pts)
2. Calculez pour chacun l'écart en points et le rapport avec le département. (4 pts)
3. Indiquez les deux indicateurs pour lesquels la commune se distingue nettement et ceux pour lesquels elle est proche du département. (2 pts)
4. L'indicateur de surpoids repose sur 148 enfants seulement. Expliquez la prudence nécessaire et proposez un moyen de la lever. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.5 – Repérer les acteurs et les ressources (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un projet sur l'alimentation des personnes âgées vivant à domicile dans la commune de Saint-Aubin-des-Landes (fictive, 6 800 habitants). Vous avez rencontré plusieurs personnes et vous devez construire la carte des acteurs.

Document 1 – Notes d'entretien

- La responsable du CCAS : « Nous gérons le portage de repas : 74 bénéficiaires. Nous avons un budget pour une action de prévention, mais pas de diététicien. »
- L'infirmière du centre de soins : « Je vois des personnes qui maigrissent sans que personne ne s'en inquiète. »
- Le président du club des aînés : « Nos 120 adhérents aiment les repas partagés, mais la salle n'a pas de cuisine équipée. »
- La pharmacienne : « Je pèse volontiers les personnes, mais je ne sais pas à qui les adresser. »
- Le chef de cuisine de la cuisine centrale : « Je prépare aussi les repas du portage ; je pourrais adapter des textures si on me forme. »
- La coordinatrice du contrat local de santé : « Le bien vieillir est un axe du CLS ; la conférence des financeurs lance un appel à projets. »
- Une habitante de 81 ans : « Je n'ai plus envie de cuisiner pour moi seule. »

À vous de jouer – Questions

1. Classez les personnes et structures du document 1 en quatre catégories : public, professionnels de terrain, partenaires opérationnels, décideurs ou financeurs. (4 pts)
2. Pour chacun, relevez une ressource qu'il apporte et une limite. (4 pts)
3. Proposez la composition d'un comité de pilotage de six personnes au plus et justifiez la présence d'une personne âgée. (2 pts)
4. Indiquez deux acteurs absents du document 1 qu'il faudrait rencontrer. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.6 – Rédiger une analyse de situation (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le foyer d'hébergement « Les Glycines » (structure fictive) accueille 46 adultes en situation de handicap psychique qui travaillent dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) voisin. Ils déjeunent au restaurant de l'ESAT et dînent au foyer, où ils préparent eux-mêmes le repas du samedi soir. La directrice vous demande la partie « analyse de situation » d'un projet sur l'alimentation des résidents.

Document 1 – Informations recueillies (données fictives, septembre 2026)

- Résidents : 46 adultes de 24 à 61 ans (29 hommes, 17 femmes) ; 21 prennent un traitement qui augmente l'appétit, selon l'infirmière.
- Le médecin du foyer indique que 19 résidents ont un IMC supérieur ou égal à 30, mesuré lors des visites annuelles.
- Repas : déjeuner à l'ESAT (self, choix entre deux plats) ; dîner livré par un prestataire du lundi au vendredi ; samedi soir préparé par les résidents avec un moniteur ; dimanche, plats surgelés.
- 27 résidents achètent des sodas ou des confiseries au distributeur du foyer chaque jour (relevé du gestionnaire).
- Cuisine du foyer : 2 plaques, un four, un réfrigérateur collectif ; budget alimentaire du samedi : 3,50 € par personne.
- Acteurs : directrice, 6 moniteurs éducateurs, une infirmière, le médecin (une demi-journée par mois), le chef de cuisine de l'ESAT, le prestataire, les familles, le conseil de la vie sociale.
- Une supérette à 400 m ; un marché le mercredi matin, pendant les heures de travail.
- Projet d'établissement 2025-2029 : « favoriser l'autonomie dans la vie quotidienne » ; le département finance des actions de prévention dans les établissements médico-sociaux.
- En réunion, des résidents disent : « On veut apprendre à faire des plats qu'on aime » ; « Le dimanche, c'est toujours pareil ».

À vous de jouer – Questions

1. Organisez les informations du document 1 selon les huit rubriques de l'analyse de situation, sous forme de tableau. (6 pts)
2. Calculez les pourcentages utiles et présentez-les avec leur source et leur date. (3 pts)
3. Relevez quatre informations manquantes et la méthode pour les obtenir. (4 pts)
4. Rédigez en cinq à six lignes une synthèse de l'analyse de situation, sans conclure trop vite sur les causes. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 7.1

1. Légendes : 1 Analyse de situation ; 2 Diagnostic et priorités ; 3 Objectifs ; 4 Plan d'action ; 5 Mise en œuvre ; 6 Évaluation ; 7 Valorisation et ajustements ; 8 Participation, partenariat, éthique.
2. Un projet de santé publique est un ensemble d'**actions coordonnées**, **limité dans le temps**, conduit **avec et pour une population**, qui répond à un **problème identifié par un diagnostic**, avec des **objectifs**, des **moyens** et une **évaluation**.
3. L'**analyse de situation** rassemble et organise les informations (territoire, population, santé, comportements, offre, acteurs, politiques, attentes). Le **diagnostic** les **interprète** : il nomme les problèmes, les besoins, leurs causes et les ressources, et prépare le choix des priorités. On ne pose pas de diagnostic sans analyse de situation, et une analyse de situation sans interprétation n'est qu'une liste de chiffres.
4. L'évaluation produit de nouvelles informations qui modifient l'analyse de situation : on ajuste les objectifs et les actions, puis on recommence. Le projet s'améliore par cycles successifs. La participation, le partenariat et l'éthique sont au centre parce qu'ils concernent toutes les étapes.

Corrigé – Exercice 7.2

1. Légendes : 1 Territoire ; 2 Population ; 3 État de santé ; 4 Comportements ; 5 Offre et environnement ; 6 Ressources et acteurs ; 7 Politiques et financements ; 8 Besoins et attentes.
2. Territoire : a), i). Population : b), j). État de santé : c). Comportements : d), k) (la fréquentation de la cantine est un comportement, mais aussi une donnée d'offre). Offre et environnement : e) ; a) et i) relèvent aussi de l'accès physique à l'offre. Ressources et acteurs : f). Politiques et financements : g), l). Besoins et attentes : h).
3. Exemples : c) n'a pas d'année ni de période (« bilan de santé de grande section, année scolaire… ») ; d) ne précise ni la date, ni l'effectif des répondants ; j) n'a ni chiffre, ni source (Insee, Filosofi, année) ; k) ne précise pas la source (registre de la cantine, mairie) ni l'année.

Corrigé – Exercice 7.3

1. a) « Beaucoup » n'est pas une mesure : pas de chiffre, pas de source, pas d'âge ; b) chiffre sans source, sans année, sans champ (quel âge ? quel territoire ?) ; c) jugement global et stigmatisant, sans indicateur ; d) source non identifiée, généralisation ; e) tendance affirmée sans chiffre, sans période ni territoire.
2. a) Service de santé scolaire : « Lors du bilan de grande section de l'année scolaire …, … % des enfants des écoles du quartier étaient en surpoids, obésité comprise (service de santé scolaire). » b) Esteban : « En France, 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient obèses (Esteban, Santé publique France, 2014-2016) » ; c'est une donnée nationale, à présenter comme telle. c) Insee, Filosofi : « Le taux de pauvreté du quartier était de … % en … (Insee, Filosofi), contre … % dans le département. » d) INCA 3 ou enquête locale : « Selon INCA 3 (ANSES, 2014-2015), … » ou « Dans notre enquête (mars 2027, 85 jeunes), … % déclarent… ». e) Data pathologies (Assurance maladie) ou Géodes : « La part de personnes traitées pour un diabète est passée de … % en … à … % en … dans le département (Assurance maladie, Data pathologies). »
3. Une donnée est toujours accompagnée de sa **source**, de son **année** (ou de sa période de recueil) et de son **champ** (âge, territoire, population), et l'on précise l'effectif quand il s'agit d'une enquête locale.
4. Le territoire du projet peut être très différent de la moyenne (revenus, âge, offre). Une donnée nationale donne un ordre de grandeur ou une **référence de comparaison**, mais elle ne décrit pas la population locale : la présenter comme locale serait une erreur de méthode.

Corrigé – Exercice 7.4

1. 60 ans et plus : 3 410 / 12 400 × 100 = **27,5 %**. Familles monoparentales : 412 / 1 830 × 100 = **22,5 %**. Ménages à bas revenus : 1 260 / 5 150 × 100 = **24,5 %**. Surpoids en grande section : 23 / 148 × 100 = **15,5 %**.

2. 60 ans et plus : 27,5 − 26,0 = **+ 1,5 point** ; rapport 27,5 / 26,0 = **1,06**. Familles monoparentales : **+ 0,5 point** ; rapport **1,02**. Ménages à bas revenus : 24,5 − 15,0 = **+ 9,5 points** ; rapport **1,63**. Surpoids : 15,5 − 9,0 = **+ 6,5 points** ; rapport **1,73**.

3. La commune se distingue nettement pour les **ménages à bas revenus** (1,63 fois plus fréquents) et le **surpoids des enfants** (1,73 fois plus fréquent). Elle est proche du département pour l'âge et les familles monoparentales (rapports de 1,06 et 1,02).

4. Avec 148 enfants, la marge d'erreur est large : 1,96 × √(0,155 × 0,845 / 148) = environ ± 5,8 points, soit un intervalle d'environ 9,7 % à 21,3 %, dont la borne basse est proche du département. On présente donc le résultat comme une tendance. Pour lever la prudence, on cumule plusieurs années scolaires de bilans ou l'on compare avec les données de la santé scolaire pour les classes de CE2 ou de 6e.

Corrigé – Exercice 7.5

1. Public : l'habitante de 81 ans, les adhérents du club, les bénéficiaires du portage. Professionnels de terrain : l'infirmière, la pharmacienne, le chef de cuisine. Partenaires opérationnels : le CCAS (portage), le club des aînés, la cuisine centrale. Décideurs ou financeurs : la coordinatrice du CLS, la conférence des financeurs, le CCAS pour son budget.

2. CCAS : ressource, le portage de 74 bénéficiaires et un budget ; limite, pas de diététicien. Infirmière : repérage des personnes qui maigrissent ; limite, pas de circuit d'orientation. Club des aînés : 120 adhérents et l'envie de repas partagés ; limite, salle sans cuisine. Pharmacienne : pesée et contact fréquent ; limite, ne sait pas à qui adresser. Chef de cuisine : capacité d'adapter les textures ; limite, besoin de formation. Coordinatrice du CLS : cadre politique et appel à projets ; limite, ne connaît pas encore les besoins précis. Habitante : expérience vécue, perte d'envie de cuisiner ; limite, son avis n'est pas représentatif à lui seul.

3. Exemple : la responsable du CCAS, la coordinatrice du CLS, l'infirmière, le président du club des aînés, une personne âgée bénéficiaire du portage, l'étudiant en diététique (ou la diététicienne référente). La présence d'une personne âgée garantit que le projet part des attentes réelles du public (participation, besoin ressenti et exprimé) et améliore son acceptabilité.

4. Les médecins généralistes (repérage de la dénutrition), les services d'aide à domicile (aides à domicile qui voient les repas), les associations de bénévoles (visites à domicile), le service de soins infirmiers à domicile.

Corrigé – Exercice 7.6

1. Tableau attendu (exemple) :

Rubrique	Informations
Territoire	Foyer en ville ; supérette à 400 m ; marché le mercredi matin, pendant le travail
Population	46 adultes de 24 à 61 ans, 29 hommes et 17 femmes, en situation de handicap psychique, travailleurs d'ESAT
État de santé	19 résidents avec un IMC ≥ 30 ; 21 traitements qui augmentent l'appétit
Comportements	27 achats quotidiens de sodas ou confiseries ; dîner du samedi préparé par les résidents
Offre et environnement	Self de l'ESAT ; prestataire du lundi au vendredi ; surgelés le dimanche ; distributeur dans le foyer ; cuisine à 2 plaques ; 3,50 € par personne le samedi

Rubrique	Informations
Ressources et acteurs	Directrice, 6 moniteurs, infirmière, médecin, chef de cuisine, prestataire, familles, conseil de la vie sociale
Politiques et financements	Projet d'établissement 2025-2029 (autonomie) ; financement départemental de la prévention
Besoins et attentes	« Apprendre à faire des plats qu'on aime » ; « Le dimanche, c'est toujours pareil »

2. IMC ≥ 30 : 19 / 46 × 100 = **41,3 %** des résidents (médecin du foyer, visites annuelles 2026). Traitement qui augmente l'appétit : 21 / 46 = **45,7 %** (infirmière, septembre 2026). Achats quotidiens au distributeur : 27 / 46 = **58,7 %** (relevé du gestionnaire, septembre 2026). Hommes : 29 / 46 = **63,0 %**.

3. Exemples : ce que mangent réellement les résidents le soir et le week-end (observation des repas, carnet sur trois jours avec l'aide d'un moniteur) ; la composition des menus du prestataire et du self (analyse des menus sur quatre semaines) ; les goûts et les compétences culinaires des résidents (entretiens ou groupe d'expression adapté) ; l'activité physique et les loisirs (questionnaire simple, échange avec les moniteurs) ; le contenu du distributeur et son contrat (gestionnaire).

4. Exemple : « Le foyer Les Glycines accueille 46 adultes en situation de handicap psychique qui travaillent en ESAT. Près de six sur dix achètent chaque jour des produits sucrés au distributeur, et le médecin relève une obésité chez 41,3 % d'entre eux, dans un contexte où près de la moitié prend un traitement qui augmente l'appétit. L'offre repose sur trois intervenants différents (self, prestataire, surgelés le dimanche), avec un seul repas préparé par les résidents. Ceux-ci demandent à cuisiner des plats qu'ils aiment. Le projet d'établissement et le financement départemental offrent un cadre favorable. Il reste à observer les repas réels et à analyser les menus avant de conclure sur les causes. »

Partie 2 – Recueillir les données sur le terrain

Objectifs – Objectifs de la partie

- Choisir une méthode de recueil adaptée à la question posée (questionnaire, entretien, groupe, observation, relevé de l'offre, analyse documentaire).
- Repérer et corriger les erreurs de rédaction d'un questionnaire.
- Construire un questionnaire en huit étapes et un guide d'entretien semi-directif.
- Concevoir une grille d'observation et un relevé de prix, et en exploiter les résultats.
- Identifier les biais d'une enquête et exploiter un prétest.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Méthodes quantitatives (combien ? quelle proportion ?) : questionnaire, relevé de l'offre. Méthodes qualitatives (pourquoi ? comment ?) : entretien semi-directif, groupe de parole, observation. On croise les méthodes : c'est la triangulation.
- Les huit étapes du questionnaire : objectif, variables, types de questions, rédaction, ordre, mention d'information RGPD, prétest auprès de 3 à 5 personnes du public, grille d'analyse prévue avant la passation.
- Règles de rédaction : une seule idée par question, pas de négation, pas de question orientée, modalités exhaustives et exclusives, période de référence courte, vocabulaire du public.
- Cinq biais : sélection, non-réponse, désirabilité sociale, mémoire, enquêteur.
- En dessous de 20 répondants, on donne toujours les effectifs.

Exercice 7.7 – Quelle méthode pour quelle question ? (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage dans un service de santé au travail interentreprises (structure fictive). Le médecin du travail souhaite connaître les habitudes de repas des salariés de trois entreprises de nettoyage et vous demande comment vous allez vous y prendre.

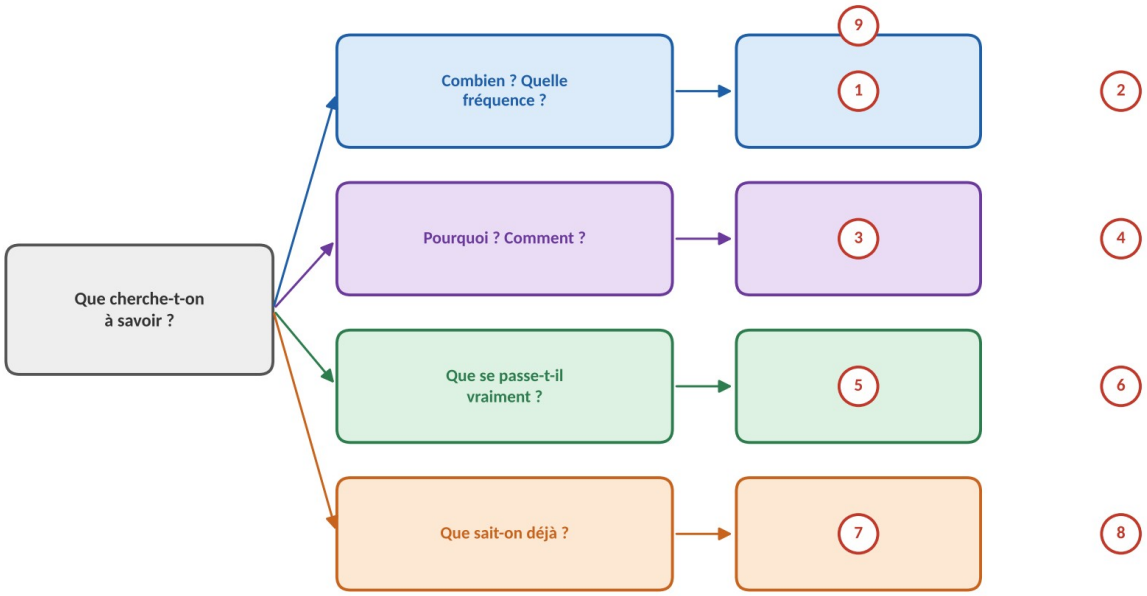


Figure 7.3 – Document 1 – Choisir une méthode de recueil (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)
2. Pour chacune des questions suivantes, choisissez la méthode la plus adaptée et justifiez : a) quelle proportion des salariés prend un repas chaud le midi ? b) pourquoi certains salariés ne mangent rien avant leur service de 5 h ? c) que contiennent réellement les distributeurs des locaux ? d) quelle est la part des salariés en horaires décalés dans le département ? (4 pts)
3. Expliquez en une phrase ce qu'est la triangulation. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.8 – Corriger un questionnaire mal rédigé (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association d'aide aux devoirs (fictive) veut interroger les parents sur le goûter des enfants. Un bénévole a préparé un premier jet et vous demande de le relire.

Document 1 – Huit questions du premier jet

1. Votre enfant mange-t-il un fruit et un laitage au goûter ?
2. Ne pensez-vous pas que les sodas sont mauvais pour la santé ?
3. Combien de fois votre enfant prend-il un goûter ? □ 1 à 2 fois □ 2 à 4 fois □ tous les jours
4. Où achetez-vous le goûter ? □ supermarché □ boulangerie
5. Votre enfant consomme-t-il des produits ultra-transformés ?
6. Votre enfant mange-t-il souvent des gâteaux ?
7. Quels sont vos revenus mensuels exacts ?
8. Ne trouvez-vous pas que les goûters industriels sont trop chers ?

À vous de jouer – Questions

1. Nommez l'erreur de chaque question du document 1. (4 pts)
2. Réécrivez chaque question de façon correcte, avec ses modalités de réponse. (4 pts)
3. Proposez l'ordre des huit questions corrigées et justifiez la place de la question sur les revenus. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.9 – Construire un questionnaire en huit étapes (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

La directrice d'un établissement régional d'enseignement adapté (EREA) fictif, dont l'internat accueille 68 élèves de 12 à 18 ans, vous demande un questionnaire court sur le petit déjeuner et la collation du soir à l'internat.

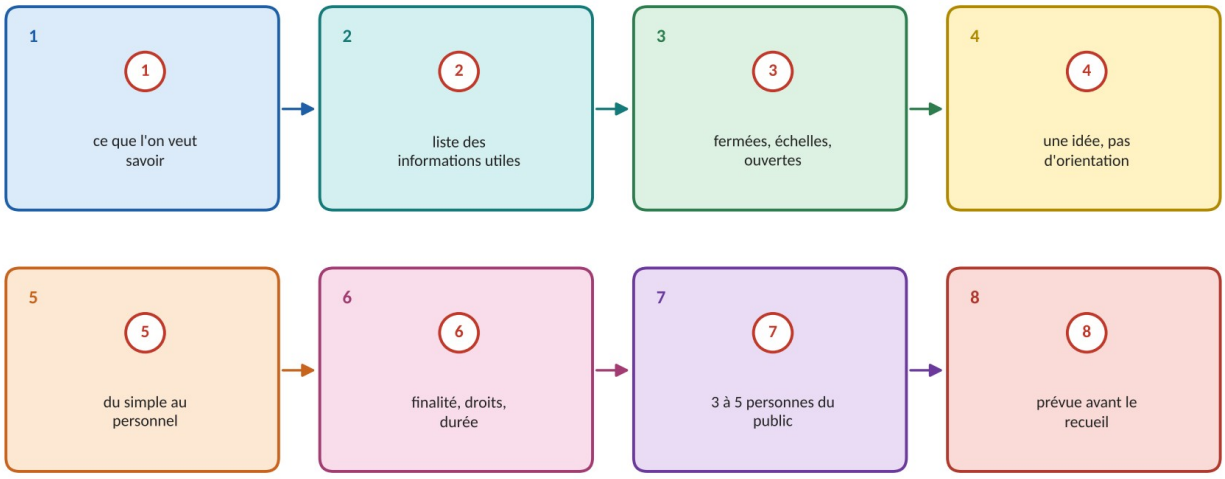


Figure 7.4 – Document 1 – Construire un questionnaire en huit étapes (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les étapes numérotées 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Formulez l'objectif du questionnaire et listez six variables utiles. (2 pts)
3. Rédigez quatre questions fermées de types différents (choix unique, choix multiples, échelle, numérique), avec leurs modalités. (4 pts)
4. Indiquez comment vous adapterez la passation à des élèves qui ont des difficultés de lecture. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.10 – Préparer et conduire un entretien semi-directif (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre d'un diagnostic sur l'alimentation des personnes accueillies dans un centre d'hébergement d'urgence (fictif), vous devez rencontrer la maîtresse de maison, qui prépare les repas du soir avec les résidents depuis six ans.

Document 1 – Extrait de votre premier entretien

Étudiante : « Les résidents mangent mal, c'est ça ? »

Maîtresse de maison : « Euh… ils mangent ce qu'on a. »

Étudiante : « Et vous leur faites des légumes ? »

Maîtresse de maison : « Quand on en a, oui. »

Étudiante : « D'accord. Et les dons de la banque alimentaire, c'est bien ? »

Maîtresse de maison : « Oui, oui, c'est bien. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez trois erreurs de l'étudiante dans le document 1 et expliquez leur effet sur les réponses. (3 pts)
2. Rédigez un guide d'entretien de quatre thèmes, avec pour chacun une question d'ouverture et deux relances. (5 pts)
3. Présentez trois règles pour conduire l'entretien (début, déroulement, fin). (2 pts)
4. Expliquez comment vous analyserez l'entretien. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.11 – Relevé de prix et accès à l'offre (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le quartier des Hauts-Prés (fictif), les habitants sans voiture font leurs courses à la supérette du quartier. Le supermarché est à 6 km, avec un bus à 1,50 € le trajet ; un marché a lieu le samedi. Vous réalisez un relevé de prix d'un panier de huit produits.

Document 1 – Relevé de prix (données fictives, octobre 2026, en euros)

Produit	Supérette du quartier	Supermarché	Marché
Pommes de terre, 1 kg	2,10	1,40	1,60
Carottes, 1 kg	2,40	1,50	1,80
Pommes, 1 kg	3,20	2,30	2,50
Lentilles vertes, 500 g	2,60	1,80	non vendu
Lait demi-écrémé, 1 L	1,35	1,05	non vendu
Œufs, boîte de 6	2,40	1,95	2,60
Pâtes, 500 g	1,30	0,95	non vendu
Riz, 1 kg	2,70	1,90	non vendu

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût du panier dans la supérette et au supermarché, l'écart en euros et le surcoût de la supérette en pourcentage. (3 pts)
2. Comparez les trois commerces sur les quatre produits vendus partout. (2 pts)
3. Un habitant prend le bus aller-retour pour acheter le panier au supermarché. Calculez son gain par rapport à la supérette, puis son gain s'il achète deux paniers en un seul trajet. (3 pts)
4. Citez deux limites d'un relevé de prix et deux informations complémentaires à recueillir. (2 pts)
5. Proposez une piste d'action tirée de ce relevé. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.12 – Biais et exploitation d'un prétest (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous menez une enquête sur l'alimentation des usagers d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA, structure fictive). Le questionnaire a été déposé à l'accueil pendant trois semaines, en libre-service. Vous avez d'abord réalisé un prétest.

Document 1 – Résultats du prétest (5 usagers)

- Durée moyenne de remplissage : 19 minutes.
- Trois usagers n'ont pas compris le mot « féculents ».
- Deux usagers ont coché deux réponses à la question « Combien de repas prenez-vous par jour ? » (modalités : 1 ; 2 ; 3 ; « ça dépend »).
- Un usager a demandé : « C'est le médecin qui va lire ça ? »

Document 2 – Résultats de la passation (64 questionnaires remplis, 210 usagers venus pendant la période)

- Question 2 (nombre de repas) : 3 non-réponses.
- Question 4 (revenus du foyer) : 23 non-réponses.
- Question 7 (consommation d'alcool la semaine dernière) : 18 non-réponses ; parmi les répondants, 80 % déclarent « 0 verre ».
- Les questionnaires ont surtout été remplis le mardi matin, jour de la consultation diététique.

À vous de jouer – Questions

1. À partir du document 1, relevez quatre problèmes du questionnaire et proposez une correction pour chacun. (4 pts)

2. Calculez le taux de participation et le taux de non-réponse aux questions 2, 4 et 7. (3 pts)

3. Identifiez trois biais possibles dans le document 2 et expliquez leur effet probable sur les résultats. (5 pts)

4. Proposez trois améliorations de la passation pour réduire ces biais. (3 pts)

5. Rédigez la phrase qui présente la limite principale de l'enquête dans le dossier. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 7.7

1. Légendes : 1 Questionnaire ; 2 chiffrer, comparer des groupes ; 3 Entretien semi-directif ; 4 comprendre les raisons, le vécu ; 5 Observation ; 6 repérer les pratiques et l'offre ; 7 Données existantes ; 8 Insee, Géodes, études, rapports ; 9 Croiser les méthodes : triangulation.
2. a) Questionnaire : on cherche une proportion, comparable entre entreprises. b) Entretien semi-directif (ou groupe de parole) : on cherche des raisons et un vécu (fatigue, horaires, transport). c) Observation et relevé de l'offre : on décrit ce qui est réellement proposé, sans passer par les déclarations. d) Données existantes : Insee, Dares ou données du service de santé au travail, avec leur année.
3. La triangulation consiste à croiser plusieurs sources ou méthodes (chiffres, paroles, observations) pour confirmer un constat : un besoin confirmé par trois regards est plus solide.

Corrigé – Exercice 7.8

1. 1 : question double (fruit et laitage). 2 : question orientée et négative. 3 : modalités qui se chevauchent (2 dans deux classes) et période floue. 4 : modalités non exhaustives. 5 : vocabulaire technique. 6 : « souvent » sans période de référence. 7 : question intrusive et précision inutile. 8 : question orientée et négative.
2. Exemples : 1a « Hier, au goûter, votre enfant a-t-il mangé un fruit ? □ oui □ non □ pas de goûter » ; 1b même question pour un laitage (yaourt, fromage, lait). 2 « Au cours de la semaine dernière, combien de jours votre enfant a-t-il bu une boisson sucrée (soda, sirop, jus) ? □ 0 □ 1 à 2 □ 3 à 4 □ 5 ou plus ». 3 « La semaine dernière, combien de jours votre enfant a-t-il pris un goûter ? □ 0 □ 1 à 2 □ 3 à 4 □ 5 à 7 ». 4 « Où achetez-vous le plus souvent le goûter ? □ supermarché □ supérette □ boulangerie □ marché □ épicerie solidaire □ fait maison □ autre (préciser) ». 5 « La semaine dernière, combien de jours votre enfant a-t-il mangé des biscuits ou des gâteaux achetés en paquet ? » (avec photos). 6 « La semaine dernière, combien de jours votre enfant a-t-il mangé des gâteaux (de toute sorte) au goûter ? □ 0 □ 1 à 2 □ 3 à 4 □ 5 à 7 ». 7 « Votre foyer bénéficie-t-il d'une aide (allocations, épicerie solidaire) ? □ oui □ non □ je préfère ne pas répondre », ou suppression si l'information n'est pas utile. 8 « Selon vous, le prix du goûter est : □ facile à assumer □ un peu lourd □ très lourd pour votre budget ».
3. Ordre : fréquence du goûter (3), lieu d'achat (4), fruit (1a), laitage (1b), gâteaux (6), biscuits en paquet (5), boissons (2), prix ressenti (8), puis la question sur les aides (7) à la fin. On place les questions personnelles et sensibles à la fin, quand la confiance est installée, avec une modalité « je préfère ne pas répondre ».

Corrigé – Exercice 7.9

1. Légendes : 1 Objectif ; 2 Variables ; 3 Types de questions ; 4 Rédaction ; 5 Ordre ; 6 Mention RGPD ; 7 Prétest ; 8 Grille d'analyse.
2. Objectif : décrire la prise du petit déjeuner et de la collation du soir des élèves internes, ainsi que leurs préférences, pour adapter l'offre de l'internat. Variables : âge (tranche), niveau de classe, prise du petit déjeuner la semaine dernière, aliments consommés, raisons de ne pas déjeuner, faim en fin de matinée, collation du soir prise ou non, souhaits.
3. Exemples. Choix unique : « Combien de matins as-tu pris un petit déjeuner la semaine dernière à l'internat ? □ 0 □ 1 à 2 □ 3 □ 4 ». Choix multiples : « Ce matin, qu'as-tu mangé ou bu ? (plusieurs réponses) □ pain □ céréales □ lait ou yaourt □ fruit ou jus □ boisson chaude □ rien ». Échelle : « À 11 h, as-tu faim ? 1 pas du tout … 5 très faim » (ou cinq visages). Numérique : « À quelle heure te lèves-tu à l'internat ? … h … ».
4. Questions lues à voix haute en petit groupe par un adulte formé, pictogrammes et photos des aliments, échelles en visages, phrases courtes, réponses en cochant uniquement, durée de 10 minutes au plus ; possibilité de répondre avec l'aide d'un surveillant sans qu'il voie les réponses.

Corrigé – Exercice 7.10

1. « Les résidents mangent mal, c'est ça ? » : question fermée et orientée, qui juge le public et pousse la personne à se défendre. « Et vous leur faites des légumes ? » : question fermée qui peut culpabiliser la professionnelle. « C'est bien ? » : question qui appelle une réponse polie, sans information. Effet : des réponses courtes, défensives ou de complaisance, qui n'apportent pas d'information sur les causes.

2. Exemple. Thème 1, les repas du soir : « Pouvez-vous me raconter comment se passe un repas du soir, du début à la fin ? » ; relances : « Qui décide du menu ? » ; « Qu'est-ce qui plaît le plus aux résidents ? ». Thème 2, l'approvisionnement : « Comment arrivent les produits que vous cuisinez ? » ; relances : « Que recevez-vous de la banque alimentaire ? » ; « Qu'est-ce qui manque le plus souvent ? ». Thème 3, les résidents : « Comment les résidents participent-ils à la cuisine ? » ; relances : « Pouvez-vous me donner un exemple ? » ; « Qu'est-ce qui les aide à participer ? ». Thème 4, les idées : « Si vous aviez un souhait pour les repas, ce serait lequel ? » ; relances : « De quoi auriez-vous besoin ? » ; « Avec qui ? ».

3. Début : se présenter, rappeler le but, la durée et la confidentialité, demander l'accord pour prendre des notes ou enregistrer. Déroulement : questions ouvertes, écoute active, reformulation, relances neutres, silence accepté, pas de jugement ni de conseil. Fin : demander si la personne veut ajouter quelque chose, remercier, expliquer ce que deviendront les informations.

4. Retranscription ou notes détaillées le jour même ; découpage du texte par thèmes (analyse thématique) ; repérage des idées qui reviennent, des freins et des leviers ; citations courtes et anonymes pour illustrer ; comparaison avec les autres entretiens et avec les données chiffrées (triangulation).

Corrigé – Exercice 7.11

1. Supérette : 2,10 + 2,40 + 3,20 + 2,60 + 1,35 + 2,40 + 1,30 + 2,70 = **18,05 €**. Supermarché : 1,40 + 1,50 + 2,30 + 1,80 + 1,05 + 1,95 + 0,95 + 1,90 = **12,85 €**. Écart : 18,05 − 12,85 = **5,20 €**. Surcoût : 5,20 / 12,85 × 100 = **40,5 %**.

2. Quatre produits communs (pommes de terre, carottes, pommes, œufs) : supérette **10,10 €**, marché **8,50 €**, supermarché **7,15 €**. Le marché est moins cher que la supérette pour les fruits et légumes, mais plus cher pour les œufs ; le supermarché reste le moins cher.

3. Un aller-retour coûte 2 × 1,50 = 3,00 €. Gain pour un panier : 18,05 − (12,85 + 3,00) = **2,20 €**. Pour deux paniers en un trajet : 2 × 5,20 − 3,00 = **7,40 €**. Le déplacement ne devient intéressant que si l'on achète en quantité, ce qui suppose de pouvoir porter les courses et de les stocker.

4. Limites : relevé à un moment donné (prix variables, promotions) ; il ne dit rien des usages réels ni des marques choisies ; il ne compte pas le temps de trajet. Informations complémentaires : où les habitants font réellement leurs courses et à quelle fréquence ; les horaires du bus et du marché ; la place de stockage ; l'existence d'une épicerie solidaire ou d'un groupement d'achat.

5. Exemples : organiser une commande groupée mensuelle de produits secs au supermarché avec livraison au centre social ; négocier avec la supérette un « panier de base » à prix réduit ; organiser un covoiturage solidaire le samedi vers le marché.

Corrigé – Exercice 7.12

1. Durée de 19 minutes, trop longue : réduire à 10 minutes en supprimant les questions non indispensables. Mot « féculents » incompris : le remplacer par des exemples et des photos (pain, pâtes, riz, pommes de terre). Modalités non exclusives (« ça dépend ») : demander « Hier, combien de repas avez-vous pris ? □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 ou plus ». Crainte que le médecin lise : ajouter une mention claire (« questionnaire anonyme, lu seulement par l'étudiante, aucune information transmise à l'équipe de soins ») et une urne fermée.

2. Taux de participation : 64 / 210 × 100 = **30,5 %**. Non-réponse : question 2 : 3 / 64 = **4,7 %** ; question 4 : 23 / 64 = **35,9 %** ; question 7 : 18 / 64 = **28,1 %**.

3. Biais de sélection et de non-réponse : seuls 30,5 % des usagers ont répondu, surtout le mardi matin (jour de la consultation diététique) ; les répondants sont sans doute plus intéressés par l'alimentation que les

autres, ce qui peut donner une image plus favorable. Biais de désirabilité sociale : 80 % de « 0 verre » dans un CSAPA, avec 28,1 % de non-réponse, suggère une sous-déclaration de l'alcool. Non-réponse à la question des revenus (35,9 %) : la question est sensible et inutilisable telle quelle. Biais d'autosélection lié au libre-service : seuls ceux qui savent lire et écrire facilement participent.

4. Proposer une passation accompagnée par un professionnel neutre ou une médiatrice, sur plusieurs jours et à différents horaires ; réduire et simplifier le questionnaire ; supprimer la question des revenus ou la remplacer par une question sur les aides perçues ; garantir l'anonymat par une urne ; compléter par quelques entretiens avec des usagers peu présents le mardi.

5. Exemple : « Les résultats portent sur 64 usagers volontaires (30,5 % des 210 usagers venus en trois semaines), recrutés surtout le jour de la consultation diététique : ils ne peuvent pas être généralisés à l'ensemble des usagers du CSAPA. »

Partie 3 – Analyser et présenter les données

Objectifs – Objectifs de la partie

- Calculer un pourcentage, un écart en points, une variation relative et un rapport sans les confondre.
- Calculer et choisir entre moyenne et médiane.
- Choisir le graphique adapté et critiquer un graphique trompeur.
- Construire un tableau croisé et calculer les pourcentages dans le bon sens.
- Calculer un risque relatif avec son intervalle de confiance et l'interpréter avec prudence.
- Rédiger un paragraphe de résultats honnête, en particulier sur de petits effectifs.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Pourcentage : n / total × 100. Écart en points : différence de deux pourcentages. Variation relative : (valeur finale − valeur initiale) / valeur initiale × 100. Passer de 25 % à 60 %, c'est + 35 points et + 140 %.
- Moyenne : somme / effectif, sensible aux valeurs extrêmes. Médiane : valeur qui partage la série ordonnée en deux moitiés, peu sensible aux valeurs extrêmes.
- Pourcentages en ligne ou en colonne : on calcule dans le sens du groupe que l'on veut comparer.
- Risque relatif RR = proportion chez les exposés / proportion chez les non-exposés ; intervalle de confiance à 95 % : exp(ln RR ± 1,96 × √(1/a − 1/(a + b) + 1/c − 1/(c + d))). Si l'intervalle contient 1, la différence n'est pas statistiquement significative.
- Une association n'est pas une preuve de causalité.
- En dessous de 20 répondants, on donne les effectifs (« 6 sur 8 ») plutôt que des pourcentages avec décimales.

Exercice 7.13 – Points ou pour cent ? (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – calcul simple · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de quartier (fictive) a mené un cycle d'ateliers « petits déjeuners » avec 60 familles. Le compte rendu rédigé par un bénévole contient des phrases à vérifier.

Document 1 – Résultats et phrases du compte rendu (données fictives)

- Avant le cycle, 18 familles sur 60 servaient un fruit au petit déjeuner au moins trois fois par semaine ; après le cycle, 33 familles sur 60.
- Dans le groupe du mercredi, 12 enfants sur 40 venaient sans avoir mangé avant le cycle ; après le cycle, 9 enfants sur 38 (deux familles ont quitté le groupe).
- Phrase A : « La part des familles qui servent un fruit a augmenté de 25 %. »
- Phrase B : « Le nombre d'enfants à jeun a baissé de 3 %. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages de familles qui servent un fruit avant et après le cycle, l'écart en points et la variation relative. (3 pts)
2. Calculez les pourcentages d'enfants venus à jeun avant et après, l'écart en points et la variation relative. (3 pts)
3. Corrigez les phrases A et B. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi il faut calculer le second pourcentage sur 38 et non sur 40. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.14 – Moyenne ou médiane ? (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un collège (fictif), des parents se plaignent que les élèves « n'ont pas le temps de manger ». Vous chronométrez, un jeudi, le temps passé à table par 15 élèves choisis au hasard au self.

Document 1 – Temps passé à table, en minutes (données fictives)

12 – 9 – 15 – 22 – 8 – 11 – 14 – 10 – 25 – 13 – 7 – 16 – 12 – 19 – 10

À vous de jouer – Questions

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant. (1 pt)
2. Calculez la moyenne, la médiane et l'étendue. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi la moyenne est supérieure à la médiane. (2 pts)
4. Calculez le nombre et le pourcentage d'élèves qui ont passé 10 minutes ou moins à table. (1 pt)
5. Indiquez deux limites de cette mesure et proposez une amélioration. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.15 – Choisir et critiquer un graphique (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez la restitution d'un diagnostic au conseil d'administration d'un centre social (fictif). Vous devez choisir les graphiques et vous relisez ceux d'une collègue.

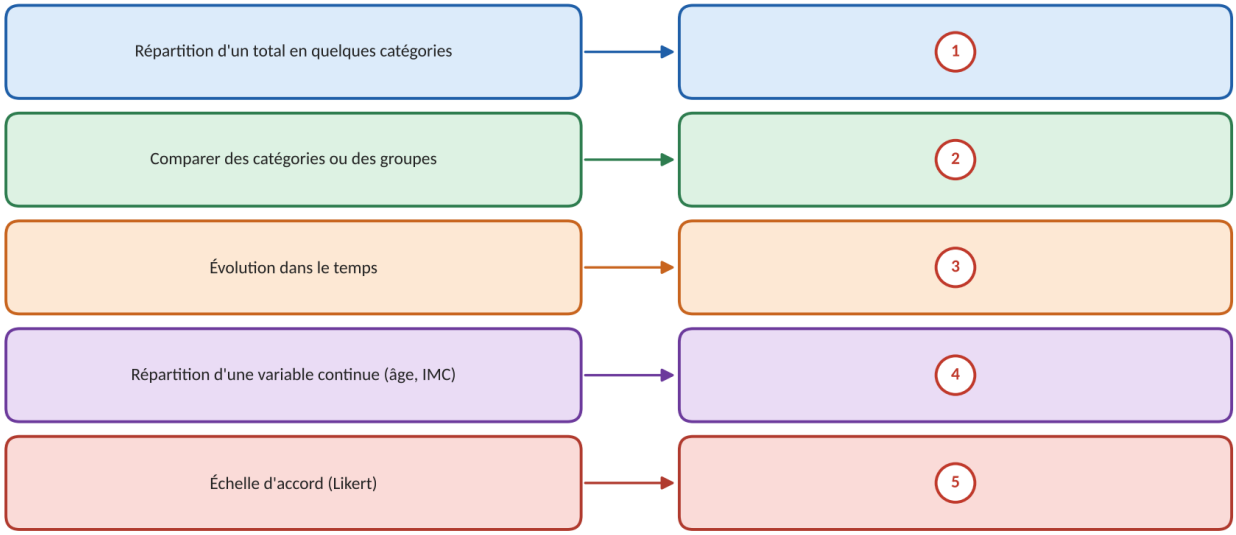


Figure 7.5 – Document 1 – Choisir un graphique selon les données (schéma à légender)

Document 2 – Données à présenter et graphiques de la collègue

a) Répartition des 84 répondants selon leur lieu principal d'achat (6 catégories).

b) Nombre d'inscrits aux ateliers chaque mois, de janvier à juin.

c) Âge des 84 répondants (de 19 à 78 ans).

d) Réponses à « Bien manger coûte cher » : tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord, pas du tout d'accord.

e) Graphique de la collègue : des barres verticales en trois dimensions dont l'axe vertical commence à 40 %, comparant 48 % de familles d'un quartier et 52 % d'un autre ; aucune source ni effectif.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Choisissez un graphique pour chacune des données a) à d) du document 2 et justifiez. (4 pts)
3. Relevez trois défauts du graphique e) et expliquez l'impression trompeuse qu'il donne. (2,5 pts)
4. Listez les éléments obligatoires d'un graphique de dossier. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.16 – Lire un tableau croisé (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'infirmière d'un collège de 480 élèves (fictif) a fait remplir par tous les élèves, en classe, une question sur le petit déjeuner du jour. Elle vous demande de l'aider à exploiter les résultats.

Document 1 – Petit déjeuner pris le jour de l'enquête, selon le niveau (données fictives, octobre 2026)

Niveau	Petit déjeuner pris	Pas de petit déjeuner	Total
6e	96	24	120
5e	88	32	120
4e	79	41	120
3e	70	50	120
Total	333	147	480

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque niveau, le pourcentage d'élèves sans petit déjeuner (pourcentage en ligne), ainsi que le pourcentage pour l'ensemble du collège. (4 pts)
2. Calculez la répartition par niveau des 147 élèves sans petit déjeuner (pourcentage en colonne). Expliquez pourquoi ces pourcentages répondent à une autre question. (3 pts)
3. Calculez le rapport entre les élèves de 3e et ceux de 6e et décrivez l'évolution selon le niveau. (2 pts)
4. Proposez deux hypothèses pour expliquer cette évolution et la méthode pour les vérifier. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.17 – Risque relatif et intervalle de confiance (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et interprétation · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le même collège, le questionnaire comportait aussi la question « Ce matin, à 10 h, te sentais-tu fatigué au point d'avoir du mal à suivre ? ». L'infirmière veut savoir si la fatigue est liée à l'absence de petit déjeuner.

Document 1 – Fatigue à 10 h selon la prise du petit déjeuner (données fictives)

Groupe	Fatigué à 10 h	Non fatigué	Total
Sans petit déjeuner	61	86	147
Avec petit déjeuner	79	254	333

Document 2 – Formule

RR = [a / (a + b)] / [c / (c + d)] ; IC à 95 % = exp(ln RR ± 1,96 × √(1/a − 1/(a + b) + 1/c − 1/(c + d))), avec a = fatigués sans petit déjeuner, b = non fatigués sans petit déjeuner, c = fatigués avec petit déjeuner, d = non fatigués avec petit déjeuner.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la proportion d'élèves fatigués dans chaque groupe. (2 pts)
2. Calculez le risque relatif et son intervalle de confiance à 95 %, en détaillant les étapes. (5 pts)
3. Interprétez le résultat en une phrase. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi ce résultat ne prouve pas que l'absence de petit déjeuner cause la fatigue ; citez deux facteurs de confusion possibles. (3 pts)
5. Indiquez comment ce résultat peut servir le projet de l'infirmière. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.18 – Rédiger les résultats d'une petite enquête (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage dans une résidence sociale (fictive) de 52 logements individuels avec kitchenette. Vous avez interrogé les résidents par questionnaire accompagné. Votre tutrice vous demande le paragraphe « Résultats » du diagnostic.

Document 1 – Résultats bruts (données fictives, novembre 2026)

- 38 résidents ont répondu sur 52 (30 hommes, 8 femmes).
- Cuisine un repas chaud chaque jour : 14 (6 femmes sur 8, 8 hommes sur 30).
- Prend habituellement ses repas seul : 27.
- Mange des fruits ou des légumes moins de cinq fois par jour : 31.
- Souhaite participer à un atelier cuisine : 22.

Document 2 – Premier jet d'une autre stagiaire

« 75 % des femmes cuisinent contre 26,67 % des hommes : les hommes ne savent pas cuisiner. Les résidents mangent mal (81,6 %). Une majorité écrasante veut des ateliers. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de participation et les pourcentages des quatre indicateurs. (3 pts)
2. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % du pourcentage de résidents qui souhaitent un atelier et interprétez-le. (3 pts)
3. Relevez quatre erreurs du document 2. (4 pts)
4. Rédigez le paragraphe « Résultats » en huit à dix lignes, avec les effectifs, sans jugement sur les personnes. (5 pts)
5. Proposez la façon de présenter ces résultats aux résidents eux-mêmes. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 7.13

1. Avant : 18 / 60 × 100 = **30,0 %** ; après : 33 / 60 × 100 = **55,0 %**. Écart : 55,0 − 30,0 = **+ 25 points**. Variation relative : (55,0 − 30,0) / 30,0 × 100 = **+ 83,3 %**.
2. Avant : 12 / 40 × 100 = **30,0 %** ; après : 9 / 38 × 100 = **23,7 %**. Écart : 23,7 − 30,0 = **− 6,3 points**. Variation relative : (23,7 − 30,0) / 30,0 × 100 = **− 21,1 %** (calcul sur les valeurs non arrondies).
3. Phrase A : « La part des familles qui servent un fruit au moins trois fois par semaine est passée de 30 % à 55 %, soit une hausse de 25 points (+ 83 %). » Phrase B : « La part des enfants venus à jeun est passée de 30 % (12 sur 40) à 24 % (9 sur 38), soit une baisse de 6 points ; avec ces petits effectifs, c'est une tendance encourageante à confirmer. »
4. Le pourcentage se calcule sur les personnes réellement présentes à la mesure. Garder 40 au dénominateur compterait deux enfants absents comme « non à jeun » et améliorerait artificiellement le résultat. On signale aussi les deux départs, qui peuvent biaiser la comparaison.

Corrigé – Exercice 7.14

1. 7 – 8 – 9 – 10 – 10 – 11 – 12 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 22 – 25.
2. Somme : 203 minutes ; moyenne : 203 / 15 = **13,5 minutes** (13,53). Médiane : 15 valeurs, la 8e valeur de la série ordonnée, soit **12 minutes**. Étendue : 25 − 7 = **18 minutes**.
3. Quelques élèves restent longtemps à table (19, 22 et 25 minutes) : ces valeurs élevées tirent la moyenne vers le haut, alors que la médiane n'en dépend presque pas. La médiane décrit mieux la situation « typique ».
4. 7, 8, 9, 10 et 10 : **5 élèves sur 15**, soit **33,3 %**.
5. Limites : un seul jour, un seul service (le jeudi peut être particulier) ; 15 élèves seulement ; le temps à table ne dit rien du temps d'attente dans la file. Amélioration : mesurer sur plusieurs jours et services, ajouter le temps d'attente et le temps total de la pause, et compléter par une question aux élèves sur leur ressenti.

Corrigé – Exercice 7.15

1. Légendes : 1 Secteurs (5 catégories au plus) ; 2 Barres (horizontales si libellés longs) ; 3 Courbe ; 4 Histogramme ; 5 Barres empilées à 100 %.
2. a) Barres horizontales triées par ordre décroissant : six catégories, c'est trop pour des secteurs lisibles. b) Courbe (ou barres) : évolution dans le temps sur six mois. c) Histogramme par classes d'âge de même amplitude (par exemple de 10 ans) : variable continue. d) Barre empilée à 100 % : échelle d'accord ordonnée.
3. L'axe vertical commence à 40 % : l'écart de 4 points paraît énorme. La 3D déforme la lecture des hauteurs. L'absence de source et d'effectifs empêche de juger la fiabilité : avec des groupes de quelques dizaines de familles, 48 % et 52 % ne sont probablement pas différents.
4. Un titre précis (qui, quoi, où, quand), les axes nommés avec leurs unités, l'axe des pourcentages qui commence à 0, les effectifs (n = …), la source et la date, une légende si plusieurs séries.

Corrigé – Exercice 7.16

1. 6e : 24 / 120 × 100 = **20,0 %** ; 5e : 32 / 120 = **26,7 %** ; 4e : 41 / 120 = **34,2 %** ; 3e : 50 / 120 = **41,7 %**. Ensemble : 147 / 480 × 100 = **30,6 %**.
2. Parmi les 147 élèves sans petit déjeuner : 6e : 24 / 147 = **16,3 %** ; 5e : **21,8 %** ; 4e : **27,9 %** ; 3e : **34,0 %**. Ces pourcentages répondent à la question « Qui sont les élèves sans petit déjeuner ? », et non « Dans quel niveau ne prend-on pas de petit déjeuner ? ». Ici, les effectifs par niveau étant égaux, les deux

classements vont dans le même sens, mais ce n'est pas toujours le cas.

3. Rapport : 41,7 / 20,0 = **2,08** : les élèves de 3e sont environ deux fois plus souvent sans petit déjeuner que ceux de 6e. La proportion augmente régulièrement avec le niveau (de 20,0 % à 41,7 %, soit + 21,7 points).

4. Hypothèses : les plus grands se lèvent plus tard ou se couchent plus tard (écrans) ; ils prennent plus souvent le bus scolaire tôt ; ils sont plus souvent seuls le matin ; préoccupations liées au poids, surtout à l'adolescence. Vérification : questions complémentaires sur l'heure du coucher et du lever, le transport, la présence d'un adulte le matin ; un petit groupe de parole par niveau.

Corrigé – Exercice 7.17

1. Sans petit déjeuner : 61 / 147 × 100 = **41,5 %** ; avec petit déjeuner : 79 / 333 × 100 = **23,7 %**.

2. RR = 0,415 / 0,237 = **1,75** (calcul non arrondi : (61 / 147) / (79 / 333)). ln RR = 0,559. Erreur type : √(1/61 − 1/147 + 1/79 − 1/333) = √(0,01639 − 0,00680 + 0,01266 − 0,00300) = √0,01925 = **0,1387**. 1,96 × 0,1387 = 0,272. Bornes : exp(0,559 − 0,272) = exp(0,287) = **1,33** ; exp(0,559 + 0,272) = exp(0,831) = **2,30**. RR = 1,75 [1,33 ; 2,30].

3. Les élèves venus sans petit déjeuner déclarent 1,75 fois plus souvent une fatigue gênante à 10 h que les autres ; l'intervalle de confiance ne contient pas 1 : l'association est statistiquement significative.

4. Il s'agit d'une enquête transversale : on mesure les deux informations au même moment, sans savoir laquelle précède l'autre. Facteurs de confusion possibles : le manque de sommeil (coucher tardif) qui entraîne à la fois un lever tardif sans petit déjeuner et la fatigue ; le niveau de classe (les 3e prennent moins de petit déjeuner et sont peut-être plus fatigués pour d'autres raisons) ; un temps de transport long. On parle d'**association**, pas de cause.

5. Le résultat appuie un besoin normatif et ressenti, il donne un argument pour mobiliser la direction et les familles, et il oriente vers des actions combinées : petit déjeuner ou collation accessible le matin, travail sur le sommeil et les écrans, information des familles. Il fournit aussi un indicateur à suivre dans l'évaluation.

Corrigé – Exercice 7.18

1. Participation : 38 / 52 × 100 = **73,1 %**. Cuisine un repas chaud chaque jour : 14 / 38 = **36,8 %**. Mange seul : 27 / 38 = **71,1 %**. Moins de cinq fruits et légumes par jour : 31 / 38 = **81,6 %**. Souhaite un atelier : 22 / 38 = **57,9 %**.

2. 1,96 × √(0,579 × 0,421 / 38) = 1,96 × 0,0801 = **0,157**, soit **± 15,7 points** ; IC à 95 % : **[42,2 % ; 73,6 %]**. On peut seulement dire qu'entre quatre et sept résidents sur dix environ souhaitent un atelier : la borne basse est sous 50 %, on ne peut donc pas affirmer qu'il s'agit d'une majorité.

3. « 75 % des femmes » porte sur 8 femmes seulement : il faut écrire « 6 femmes sur 8 ». « 26,67 % » : décimales inutiles. « Les hommes ne savent pas cuisiner » : interprétation non démontrée (ils peuvent manquer d'équipement, d'envie ou de temps) et jugement sur les personnes. « Les résidents mangent mal » : jugement global, alors que l'indicateur porte seulement sur les fruits et légumes. « Majorité écrasante » : faux au regard de l'intervalle de confiance.

4. Exemple : « 38 résidents sur 52 ont répondu (73,1 %), dont 30 hommes et 8 femmes. Un peu plus d'un tiers (14 sur 38) cuisinent un repas chaud chaque jour : c'est le cas de 6 femmes sur 8 et de 8 hommes sur 30 ; cet écart repose sur de petits effectifs et ses raisons restent à explorer en entretien (équipement, savoir-faire, envie). La grande majorité des répondants prennent leurs repas seuls (27 sur 38) et déclarent manger des fruits ou des légumes moins de cinq fois par jour (31 sur 38). 22 résidents sur 38 souhaitent participer à un atelier cuisine (57,9 %, intervalle de confiance de 42 à 74 %). Les 14 non-répondants ne sont pas décrits : les résultats peuvent ne pas refléter leur situation. »

5. Une restitution orale conviviale, autour d'un café, avec des chiffres simples (« 22 personnes sur 38 ») et des pictogrammes, en invitant les résidents à réagir et à proposer les thèmes des ateliers.

Partie 4 – Échantillonnage et précision

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir population, base de sondage, échantillon et taux de sondage.
- Distinguer les méthodes probabilistes et non probabilistes, et choisir une méthode réaliste en stage.
- Répartir un échantillon stratifié proportionnel et construire des quotas.
- Calculer la marge d'erreur et l'intervalle de confiance d'un pourcentage.
- Calculer une taille d'échantillon, avec la correction pour population finie et le taux de réponse attendu.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Population : ensemble des personnes visées. Base de sondage : liste complète de cette population. Échantillon : partie de la population réellement interrogée. Taux de sondage : n / N.
- Méthodes probabilistes : aléatoire simple, systématique (pas k = N / n), stratifiée, par grappes. Méthodes non probabilistes : quotas, convenance (risque de biais de sélection).
- Marge d'erreur à 95 % : $e = 1{,}96 \times \sqrt{p \times (1 - p) / n}$; intervalle $[p - e ; p + e]$.
- Taille d'échantillon : $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$ ($p = 0{,}5$ si l'on ne sait rien) ; ± 5 points → 385 ; ± 8 points → 151 ; ± 10 points → 97.
- Correction pour population finie : $n' = n / (1 + (n - 1) / N)$. On arrondit toujours une taille d'échantillon à l'entier supérieur.
- Pour tenir compte du taux de réponse attendu : nombre de personnes à solliciter = n' / taux de réponse.

Exercice 7.19 – Les méthodes d'échantillonnage (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous présentez à votre groupe de stage les différentes façons de choisir les personnes à interroger, avant une enquête dans une ville moyenne.

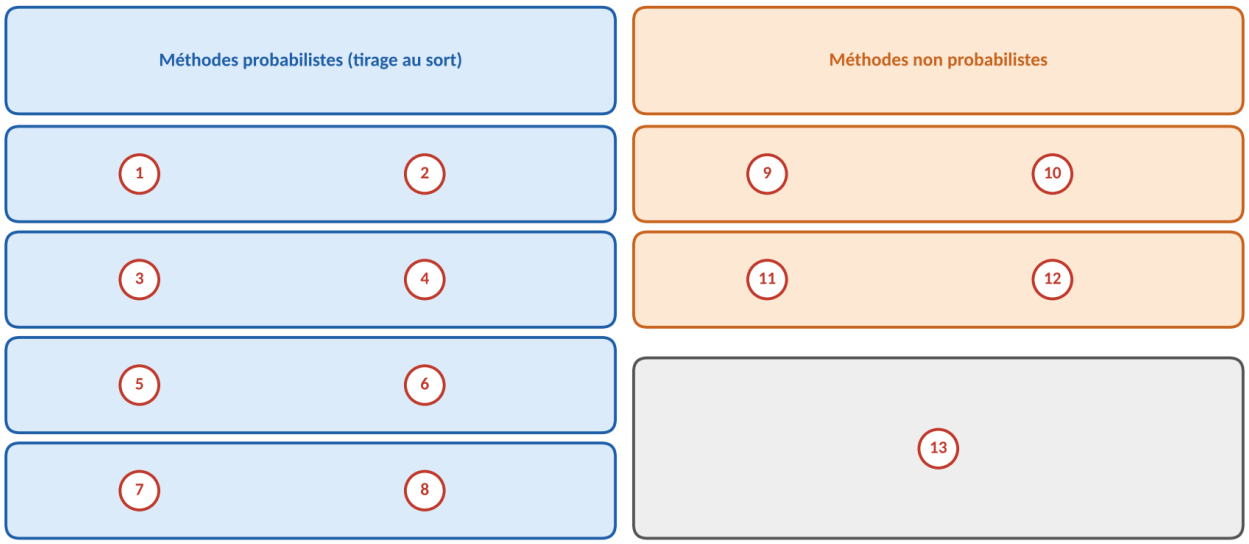


Figure 7.6 – Document 1 – Les principales méthodes d'échantillonnage (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 13 du document 1. (6,5 pts)
2. Définissez population, échantillon et taux de sondage. (1,5 pt)
3. Associez chaque situation à une méthode : a) on tire au sort 5 classes parmi les 24 d'un collège et on interroge tous leurs élèves ; b) on interroge les parents présents à la sortie de l'école ; c) on prend un adhérent sur dix dans la liste alphabétique, à partir du 7e ; d) on interroge 30 hommes et 34 femmes, en respectant la répartition par âge de l'Insee. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.20 – Un échantillon stratifié dans un lycée professionnel (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – calcul guidé · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le lycée professionnel des Métiers de Bouche (fictif) compte 864 élèves. L'infirmière souhaite interroger 180 élèves sur leurs repas, en respectant le poids de chaque niveau.

Document 1 – Effectifs par niveau (données fictives, rentrée 2026)

Niveau	Effectif
CAP 1re année	156
CAP 2e année	132
Seconde professionnelle	214
Première professionnelle	190
Terminale professionnelle	172
Total	864

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de sondage. (1 pt)
2. Calculez le nombre théorique d'élèves à interroger dans chaque niveau. (3 pts)
3. Arrondissez pour obtenir exactement 180 élèves, par la méthode des plus forts restes (on arrondit d'abord à l'entier inférieur, puis on ajoute une unité aux niveaux qui ont la plus grande partie décimale, jusqu'à atteindre le total). (3 pts)
4. Expliquez l'intérêt de la stratification par rapport à un tirage aléatoire simple. (2 pts)
5. Indiquez comment tirer les élèves au sort dans chaque niveau. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.21 – Tirage systématique et quotas (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – calcul guidé · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association des jardins familiaux de la Vallée Verte (fictive) compte 615 adhérents. Elle souhaite interroger 123 adhérents sur leur consommation de légumes. Dans un second temps, la mairie veut interroger 120 habitants du quartier voisin, sans liste disponible.

Document 1 – Structure de la population du quartier (données fictives)

Femmes : 54 % ; hommes : 46 %. Moins de 30 ans : 22 % ; 30 à 59 ans : 50 % ; 60 ans et plus : 28 %.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pas de sondage pour les adhérents. Le premier numéro tiré au sort est 3 : donnez les quatre premiers numéros tirés et le dernier. (3 pts)
2. Indiquez une condition pour que ce tirage systématique ne soit pas biaisé. (1 pt)
3. Pour les 120 habitants, calculez les quotas par sexe et par âge. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi les quotas ne sont pas une méthode probabiliste et citez un risque. (2 pts)
5. Proposez une précaution pour limiter ce risque. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.22 – Marge d'erreur et intervalle de confiance (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et interprétation · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une enquête par questionnaire a été menée auprès de 185 agents tirés au sort dans une collectivité territoriale (fictive). 74 agents déclarent sauter le déjeuner au moins une fois par semaine. Un collègue a mené la même enquête dans un service de 60 agents et trouve 24 agents dans ce cas.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage d'agents qui sautent le déjeuner dans chaque enquête. (1 pt)
2. Calculez la marge d'erreur et l'intervalle de confiance à 95 % de chaque pourcentage, en détaillant les étapes. (5 pts)
3. Comparez les deux intervalles et expliquez l'effet de la taille de l'échantillon. (2 pts)
4. Le directeur affirme : « 40 % des agents de la collectivité sautent le déjeuner. » Reformulez correctement. (2 pts)
5. Indiquez une condition pour que cet intervalle de confiance ait un sens. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.23 – Calculer une taille d'échantillon (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La même collectivité compte 1 150 agents. Avant une nouvelle enquête, le service de prévention vous demande combien d'agents il faut interroger pour estimer, à ± 5 points près, la proportion d'agents qui sautent le déjeuner. Une enquête nationale fictive suggère une proportion voisine de 30 %. Le taux de réponse attendu est de 70 %.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la taille d'échantillon nécessaire avec p = 0,30, sans correction. (3 pts)
2. Appliquez la correction pour population finie. (3 pts)
3. Calculez le nombre d'agents à solliciter en tenant compte du taux de réponse. (2 pts)
4. Refaites les calculs 1 et 2 avec p = 0,5 et expliquez quand on choisit cette valeur. (3 pts)
5. Indiquez ce que vous feriez si le service ne peut organiser que 150 questionnaires. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.24 – Choisir une stratégie d'échantillonnage réaliste (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un bailleur social (fictif) gère 1 860 logements répartis dans 23 résidences d'une agglomération. Il souhaite connaître l'équipement de cuisine et les habitudes de courses des locataires avant de financer des ateliers. Vous disposez de quatre jours de terrain avec deux médiatrices. La liste des locataires ne peut pas vous être transmise (protection des données) ; seule la liste des résidences et de leur nombre de logements est disponible.

Document 1 – Contraintes et informations

- Objectif : environ 250 questionnaires remplis.
- Taux de réponse attendu en porte-à-porte avec médiatrice : 55 %.
- Les résidences sont de tailles différentes (de 32 à 140 logements) et situées dans trois secteurs (centre, est, ouest).
- Les médiatrices parlent arabe, turc et anglais ; une partie des locataires ne lit pas le français.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi un tirage aléatoire simple des locataires n'est pas possible ici. (2 pts)
2. Calculez le nombre de logements à solliciter et le nombre de résidences à tirer au sort, sachant qu'une résidence compte en moyenne 1 860 / 23 logements. (4 pts)
3. Proposez une méthode par grappes stratifiée par secteur et décrivez le tirage. (4 pts)
4. Expliquez pourquoi un échantillon par grappes est moins précis qu'un échantillon aléatoire simple de même taille. (2 pts)
5. Présentez deux précautions éthiques et pratiques liées au porte-à-porte. (2 pts)
6. Rédigez la phrase de méthode du dossier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 7.19

1. Légendes : 1 Aléatoire simple ; 2 même chance pour chacun ; liste complète ; 3 Systématique ; 4 une personne toutes les k sur la liste ; 5 Stratifié ; 6 tirage dans chaque groupe, selon son poids ; 7 Par grappes ; 8 groupes entiers tirés au sort ; 9 Par quotas ; 10 reproduit la structure connue de la population ; 11 De convenance ; 12 personnes disponibles : risque de biais de sélection ; 13 Base de sondage = liste complète de la population, nécessaire au tirage au sort.
2. Population : l'ensemble des personnes que l'on veut décrire. Échantillon : la partie de la population réellement interrogée. Taux de sondage : rapport entre la taille de l'échantillon et celle de la population (n / N).
3. a) Par grappes ; b) de convenance ; c) systématique (pas de 10) ; d) par quotas.

Corrigé – Exercice 7.20

1. Taux de sondage : 180 / 864 = **0,2083** (20,8 %).
2. CAP 1re année : 156 × 0,2083 = **32,5** ; CAP 2e année : 132 × 0,2083 = **27,5** ; seconde : 214 × 0,2083 = **44,58** ; première : 190 × 0,2083 = **39,58** ; terminale : 172 × 0,2083 = **35,83** (calculs avec 180 / 864 non arrondi).
3. Entiers inférieurs : 32 + 27 + 44 + 39 + 35 = 177 ; il manque 3 élèves. Plus grandes parties décimales : terminale (0,83), seconde (0,58), première (0,58). Répartition : **32, 27, 45, 40, 36**, soit 180 élèves.
4. La stratification garantit que chaque niveau est représenté selon son poids, même les petits niveaux ; un tirage simple pourrait, par hasard, sous-représenter un niveau. Elle permet aussi des résultats par niveau et améliore un peu la précision.
5. Dans chaque niveau, à partir de la liste des élèves : tirage aléatoire (tableur, fonction ALEA) ou tirage systématique avec un point de départ tiré au sort.

Corrigé – Exercice 7.21

1. Pas : k = 615 / 123 = **5**. Numéros : 3, 8, 13, 18… Dernier : 3 + 5 × 122 = **613**.
2. La liste ne doit pas suivre un ordre périodique lié au sujet de l'enquête (par exemple, une liste classée par parcelle où chaque 5e parcelle serait la plus grande) ; on utilise de préférence une liste alphabétique.
3. Femmes : 0,54 × 120 = 64,8, soit **65** ; hommes : 120 − 65 = **55**. Moins de 30 ans : 0,22 × 120 = 26,4, soit **26** ; 30 à 59 ans : 0,50 × 120 = **60** ; 60 ans et plus : 0,28 × 120 = 33,6, soit **34** ; total 26 + 60 + 34 = 120.
4. Les personnes ne sont pas tirées au sort : c'est l'enquêteur qui les choisit dans chaque case. On ne peut donc pas calculer rigoureusement une marge d'erreur. Risque : interroger les personnes les plus disponibles ou les plus faciles à aborder (biais de sélection), par exemple uniquement celles qui sont dehors en journée.
5. Diversifier les lieux et les horaires de passation (marché, sortie d'école, centre social, soirée, samedi) et décrire honnêtement la méthode dans le dossier.

Corrigé – Exercice 7.22

1. Collectivité : 74 / 185 = **40,0 %** ; service : 24 / 60 = **40,0 %**.
2. Collectivité : p × (1 − p) = 0,40 × 0,60 = 0,24 ; 0,24 / 185 = 0,001297 ; √ = 0,0360 ; × 1,96 = **0,071**, soit **± 7,1 points** ; IC : **[32,9 % ; 47,1 %]**. Service : 0,24 / 60 = 0,004 ; √ = 0,0632 ; × 1,96 = **0,124**, soit **± 12,4 points** ; IC : **[27,6 % ; 52,4 %]**.
3. Les deux enquêtes donnent le même pourcentage, mais l'intervalle du service est presque deux fois plus large. La marge d'erreur diminue quand la taille de l'échantillon augmente, comme la racine carrée de n : il faut multiplier n par 4 pour diviser la marge par 2.

4. « Selon notre enquête auprès de 185 agents tirés au sort (date), 40 % déclarent sauter le déjeuner au moins une fois par semaine ; dans l'ensemble de la collectivité, cette proportion se situe probablement entre 33 % et 47 %. »

5. L'échantillon doit être tiré au hasard dans la population ; sinon, l'intervalle ne mesure pas les biais (sélection, non-réponse). Il faut aussi que les réponses soient indépendantes et que l'effectif soit suffisant.

Corrigé – Exercice 7.23

1. $n = 1{,}96^2 \times 0{,}30 \times 0{,}70 / 0{,}05^2 = 3{,}8416 \times 0{,}21 / 0{,}0025 =$ **322,7**, soit **323 agents**.

2. $n' = 323 / (1 + 322 / 1\,150) = 323 / 1{,}280 =$ **252,3**, soit **253 agents**.

3. 253 / 0,70 = **361,4**, soit **362 agents** à solliciter.

4. $n = 3{,}8416 \times 0{,}25 / 0{,}0025 =$ **384,2**, soit **385** ; $n' = 385 / (1 + 384 / 1\,150) = 385 / 1{,}334 =$ **288,6**, soit **289 agents**. On prend p = 0,5 quand on n'a aucune estimation préalable : c'est la valeur qui donne la plus grande taille, donc la plus prudente.

5. Accepter une marge plus large et la calculer (avec 150 réponses et p = 0,30 : $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}21 / 150)}$ = environ ± 7,3 points), ou cibler une population plus petite et le dire ; ne jamais annoncer une précision qu'on n'a pas.

Corrigé – Exercice 7.24

1. Il n'existe pas de base de sondage des locataires accessible (protection des données) : on ne peut pas donner à chaque locataire la même chance d'être tiré.

2. Logements à solliciter : 250 / 0,55 = 454,5, soit **455 logements**. Taille moyenne d'une résidence : 1 860 / 23 = **80,9**, soit environ 81 logements. Nombre de résidences : 455 / 81 = 5,6, soit **6 résidences** (6 × 81 = 486 logements, soit environ 267 questionnaires attendus).

3. Grappes stratifiées : on classe les 23 résidences par secteur (centre, est, ouest) et l'on tire au sort deux résidences dans chaque secteur (tirage proportionnel au nombre de logements si possible). Dans chaque résidence tirée, on sollicite tous les logements, en passant à des horaires variés (fin d'après-midi, samedi) et en revenant une seconde fois chez les absents.

4. Les personnes d'une même résidence se ressemblent (même quartier, même âge du bâti, mêmes commerces) : interroger tout un immeuble apporte moins d'informations nouvelles que des personnes dispersées. C'est l'effet de grappe : la précision réelle est plus faible que celle calculée avec la formule simple.

5. Information préalable des locataires par affichage et par le gardien ; passage en binôme, carte professionnelle visible ; participation libre et anonyme, sans entrer dans le logement si la personne ne le souhaite pas ; questionnaire proposé à l'oral dans la langue de la personne ; aucune information transmise au bailleur sur un locataire identifiable.

6. Exemple : « L'enquête a été menée en porte-à-porte du … au …, dans 6 résidences tirées au sort à raison de deux par secteur (échantillonnage par grappes stratifié), auprès de tous les logements de ces résidences ; … questionnaires ont été remplis sur 486 logements sollicités (… %). »

Partie 5 – Poser le diagnostic

Objectifs – Objectifs de la partie

- Classer des besoins selon Bradshaw et vérifier un besoin par la triangulation.
- Construire un arbre à problèmes à partir de faits et formuler un problème central correct.
- Analyser l'environnement alimentaire d'un territoire avec des indicateurs chiffrés.
- Confronter des sources qui semblent se contredire.
- Mesurer des inégalités sociales de santé (écart absolu, rapport, gradient).
- Rédiger la partie « diagnostic » d'un dossier.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Besoins (Bradshaw, 1972) : normatif (défini par des experts au regard d'une norme), ressenti (perçu par les personnes), exprimé (devenu demande), comparatif (écart avec une population de référence). Un besoin confirmé par plusieurs types est plus solide (triangulation).
- Problème central : situation négative, observable et mesurable, jamais l'absence d'une solution (« il n'y a pas d'atelier » n'est pas un problème).
- Arbre à problèmes : causes (avec des faits) → problème central → conséquences.
- Environnement alimentaire : densité de commerces (pour 1 000 habitants), indice d'environnement favorable = commerces favorables / (favorables + défavorables) × 100, distance au commerce de fruits et légumes, prix d'un panier de référence. Désert alimentaire : accès difficile ; marais alimentaire : offre abondante mais surtout défavorable.
- Inégalités sociales de santé : écart absolu (en points) et rapport entre groupes extrêmes ; gradient social : la santé s'améliore à chaque échelon de l'échelle sociale. Universalisme proportionné (Marmot, 2010) : des actions pour tous, d'intensité proportionnée aux besoins.

Exercice 7.25 – Les quatre types de besoins (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous réalisez le diagnostic d'un projet sur l'alimentation des enfants accueillis dans un centre de loisirs intercommunal (fictif) pendant les vacances. Vous avez réuni plusieurs constats.

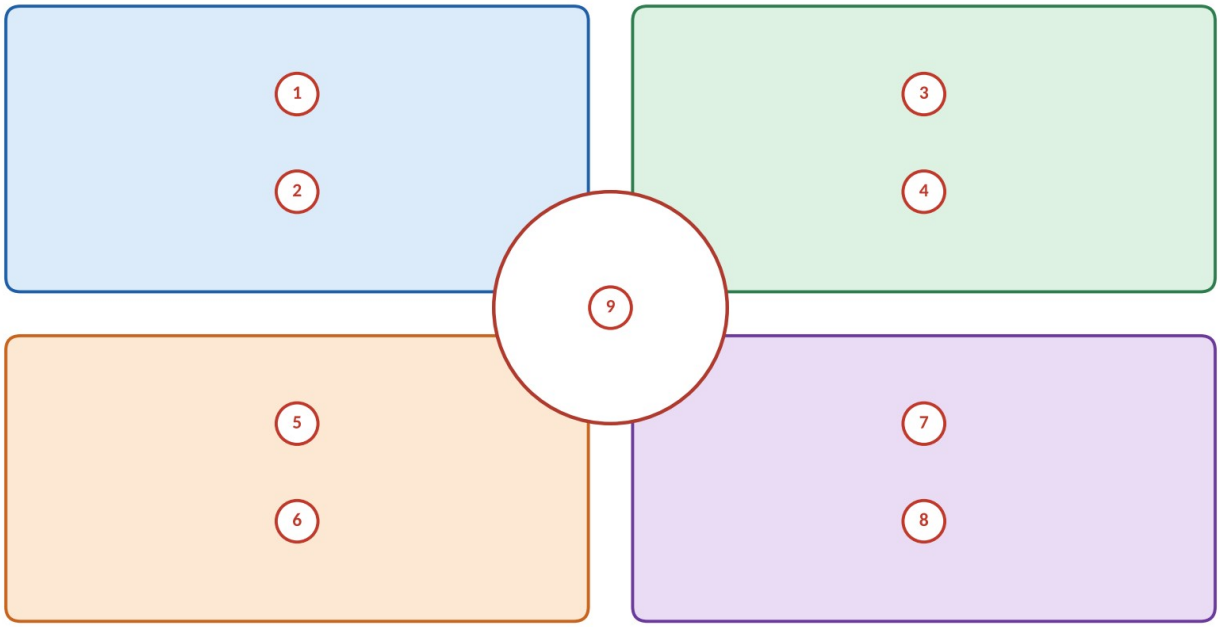


Figure 7.7 – Document 1 – Les besoins selon Bradshaw (schéma à légender)

Document 2 – Huit constats

a) Le goûter servi contient un produit sucré chaque jour, alors que les recommandations pour la restauration collective en limitent la fréquence.

b) 14 familles ont écrit à la mairie pour demander des goûters « plus sains ».

c) Les animateurs disent : « Les enfants ont faim à 16 h, le goûter ne tient pas. »

d) Dans ce centre, 19 % des enfants boivent de l'eau au goûter, contre 54 % dans les centres du département ayant adopté une charte.

e) Des enfants disent : « On aimerait des fruits coupés. »

f) Le médecin de PMI rappelle que l'eau est la seule boisson recommandée à volonté.

g) Une liste d'attente de 22 enfants existe pour l'atelier « cuisine des petits chefs ».

h) Le coût du goûter est de 0,42 € par enfant, contre 0,55 € en moyenne dans les centres voisins.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)
2. Classez les huit constats du document 2 selon le type de besoin. (4 pts)
3. Indiquez le besoin le mieux confirmé par la triangulation et justifiez. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.26 – Construire un arbre à problèmes (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le village de Montclar-sur-Aune (fictif, 740 habitants), la dernière épicerie a fermé. Le CCAS a interrogé 41 habitants de 70 ans et plus vivant seuls. Vous devez construire l'arbre à problèmes.

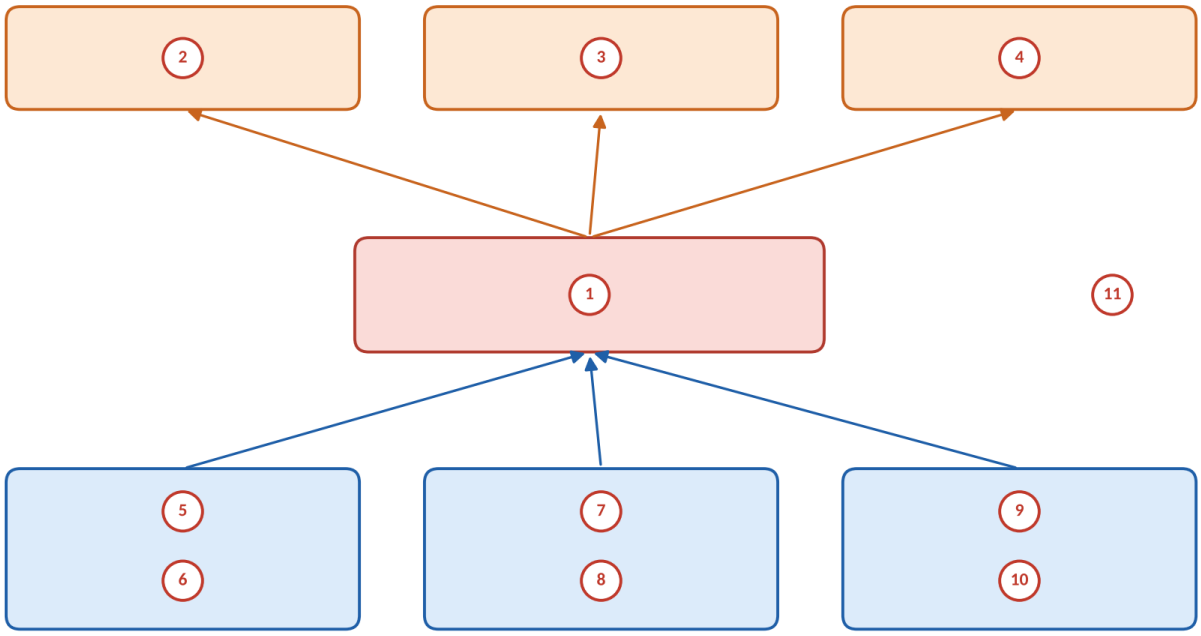


Figure 7.8 – Document 1 – L'arbre à problèmes (schéma à légender)

Document 2 – Résultats et notes (données fictives, octobre 2026)

- 25 personnes sur 41 mangent de la viande, du poisson ou des œufs moins d'une fois par jour.
- 17 n'ont plus de voiture ; le bus passe deux fois par semaine.
- 22 disent : « Cuisiner pour soi seul, ça ne vaut pas la peine. »
- 9 ont des difficultés pour mâcher.
- 12 ont perdu du poids sans le vouloir depuis un an, selon leurs déclarations.
- 6 ont chuté dans l'année.
- Le portage de repas coûte 9,20 € par repas ; 5 personnes l'utilisent.
- Le marché du bourg voisin a lieu le jeudi matin.
- 15 personnes disent se sentir seules « souvent » ou « toujours ».

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 11 du document 1. (3 pts)
2. Formulez le problème central avec un fait chiffré. (2 pts)
3. Construisez l'arbre à problèmes : au moins quatre causes et trois conséquences tirées du document 2, avec leur pourcentage. (5 pts)
4. Expliquez pourquoi « il n'y a pas d'épicerie » n'est pas un bon problème central, et pourquoi c'est pourtant une cause importante. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 7.27 – Mesurer l'environnement alimentaire d'un quartier (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le quartier de la Gare de Saint-Ferlac (fictif, 5 600 habitants) est souvent décrit comme « bien commerçant ». Vous réalisez un repérage dans un rayon de 800 m autour du centre social.

Document 1 – Repérage (données fictives, octobre 2026)

- Commerces proposant des produits frais et des produits de base : une supérette, un primeur, un marché le mercredi.
- Commerces proposant surtout des produits peu favorables à la santé : six restaurants rapides, deux boulangeries spécialisées dans le snacking, deux épiceries de nuit (confiseries, boissons, alcool).
- Un ménage type du quartier (deux personnes) déclare un budget alimentaire de 180 € par mois.
- Le panier de huit produits de base relevé à la supérette coûte 18,05 € ; le même panier coûte 12,85 € au supermarché, à 6 km.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'indice d'environnement favorable, la densité de commerces pour 1 000 habitants et le rapport entre restaurants rapides et commerces favorables. (4 pts)

2. Indiquez si le quartier relève d'un désert ou d'un marais alimentaire. Justifiez. (2 pts)

3. Calculez le budget alimentaire du ménage par personne et par jour, et la part de ce budget mensuel représentée par un seul panier de base à la supérette et au supermarché. (3 pts)

4. Présentez deux limites de ce repérage. (1 pt)

5. Proposez deux actions sur l'environnement, et non sur les seuls comportements. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.28 – Quand les sources se contredisent (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une cité scolaire (fictive), vous cherchez à savoir si les collégiens mangent les légumes servis au restaurant scolaire. Trois sources donnent des réponses différentes.

Document 1 – Trois sources (données fictives, novembre 2026)

- Questionnaire rempli en classe par 212 élèves : 153 déclarent « manger les légumes servis le midi presque tous les jours ».
- Observation des plateaux au retour, sur quatre jours, 600 plateaux : la portion de légumes est laissée entière ou presque sur 342 plateaux.
- Entretien avec le chef : « Les légumes partent à la poubelle, sauf les frites et le maïs. Les élèves ont 25 minutes pour tout faire. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages des deux premières sources. (2 pts)
2. Expliquez l'écart entre la déclaration et l'observation par au moins deux biais ou différences de méthode. (4 pts)
3. Indiquez ce que l'entretien apporte et ses limites. (2 pts)
4. Rédigez la conclusion du diagnostic sur ce point, en trois lignes, en croisant les trois sources. (3 pts)
5. Proposez une quatrième source pour compléter. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.29 – Mesurer les inégalités sociales (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un observatoire régional de santé (fictif) publie la part d'enfants de grande section en surpoids, obésité comprise, selon le niveau de revenu de la commune de l'école, classé en cinq groupes de même taille (quintiles). Le conseil départemental veut cibler les communes les plus pauvres.

Document 1 – Surpoids des enfants de grande section selon le quintile de revenu (données fictives, années scolaires 2023 à 2025)

Quintile de revenu de la commune	Q1 (plus pauvres)	Q2	Q3	Q4	Q5 (plus aisées)
Surpoids, obésité comprise	21,4 %	18,0 %	15,2 %	12,6 %	9,8 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'écart absolu et le rapport entre Q1 et Q5. (2 pts)
2. Décrivez la forme des résultats et nommez-la. (2 pts)
3. Calculez la moyenne simple des cinq quintiles. Combien de quintiles sont au-dessus et combien au-dessous de cette moyenne ? (2 pts)
4. Expliquez pourquoi une action réservée au seul quintile Q1 ne suffirait pas, avec le principe de l'universalisme proportionné. (4 pts)
5. Proposez une façon d'appliquer ce principe à un programme d'ateliers dans les écoles du département. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.30 – Rédiger le diagnostic d'un chantier d'insertion (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le chantier d'insertion maraîcher « Les Jardins du Pont-Vieux » (fictif) emploie 24 salariés en contrat d'insertion. Ils cultivent des légumes biologiques vendus en paniers à des adhérents. L'encadrante technique remarque des coups de fatigue en fin de matinée et vous demande un diagnostic.

Document 1 – Résultats d'entretiens individuels courts (données fictives, octobre 2026, 24 salariés sur 24)

- 15 arrivent au travail sans avoir rien mangé.
- 11 n'ont pas de cuisine équipée chez eux (hébergement, chambre, foyer).
- 9 disposent de moins de 5 € par jour pour se nourrir.
- 6 mangent des légumes tous les jours.
- 18 aimeraient pouvoir emporter des légumes du chantier.
- Les légumes non calibrés (environ 40 kg par semaine) sont compostés.
- Une salle de pause avec réfrigérateur et four à micro-ondes existe ; le déjeuner est pris sur place, apporté par chacun.
- Paroles : « Je cultive des courgettes toute la journée, mais je n'en mange jamais » ; « Le matin, je n'ai pas le temps, le bus est à 6 h 40 ».

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages utiles. (3 pts)

2. Repérez le paradoxe de cette situation. (2 pts)

3. Classez les besoins selon Bradshaw. (3 pts)

4. Rédigez le diagnostic en dix lignes environ : problème central, causes principales, conséquences, ressources, en restant prudent sur les liens de cause à effet. (6 pts)

5. Proposez deux pistes d'action qui découlent directement du diagnostic. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 7.25

1. Légendes : 1 Besoin normatif ; 2 écart à une norme fixée par des experts ; 3 Besoin ressenti ; 4 manque perçu par les personnes ; 5 Besoin exprimé ; 6 besoin ressenti devenu demande ; 7 Besoin comparatif ; 8 écart avec une population de référence ; 9 Triangulation : besoin confirmé par plusieurs regards.
2. Normatif : a), f). Ressenti : c) (ressenti par les professionnels), e). Exprimé : b), g). Comparatif : d), h).
3. Le besoin d'un goûter plus favorable à la santé (moins de produits sucrés, plus de fruits et d'eau) est confirmé par les quatre regards : la norme (a, f), le ressenti des enfants et des animateurs (c, e), la demande des familles (b) et la comparaison avec les autres centres (d). C'est le besoin le plus solide.

Corrigé – Exercice 7.26

1. Légendes : 1 Problème central : situation négative, observable et mesurable ; 2 Conséquences sur la santé ; 3 Conséquences sociales ; 4 Conséquences économiques ; 5 Causes individuelles ; 6 connaissances, compétences, goûts ; 7 Causes environnementales ; 8 offre, prix, accès, équipement ; 9 Causes sociales et organisationnelles ; 10 horaires, isolement, normes ; 11 chaque cause appuyée par un fait chiffré.
2. Exemple : « Les personnes de 70 ans et plus vivant seules à Montclar-sur-Aune ont une alimentation insuffisante en protéines : 25 sur 41 (61,0 %) mangent de la viande, du poisson ou des œufs moins d'une fois par jour. »
3. Causes : absence d'épicerie et transports limités (17 sur 41 sans voiture, soit 41,5 % ; bus deux fois par semaine) ; perte d'envie de cuisiner pour soi seul (22 sur 41, soit 53,7 %) ; difficultés de mastication (9 sur 41, soit 22,0 %) ; isolement (15 sur 41, soit 36,6 %) ; coût du portage (9,20 € le repas, utilisé par 5 personnes seulement). Conséquences : perte de poids involontaire (12 sur 41, soit 29,3 %) et risque de dénutrition ; chutes (6 sur 41, soit 14,6 %) et perte d'autonomie ; isolement renforcé ; dépendance accrue aux aides et coûts de soins.
4. « Il n'y a pas d'épicerie » décrit l'absence d'une solution, pas l'état du public ; un problème central doit porter sur la situation des personnes (leur alimentation, leur santé), pour laquelle plusieurs solutions sont possibles. La fermeture de l'épicerie reste une cause environnementale majeure : elle limite l'accès aux produits frais et rend les personnes sans voiture dépendantes du bus ou de l'entourage.

Corrigé – Exercice 7.27

1. Commerces favorables : 3 ; défavorables : 6 + 2 + 2 = 10 ; total : 13. Indice d'environnement favorable : 3 / 13 × 100 = **23,1** (sur 100). Densité : 13 / 5 600 × 1 000 = **2,32 commerces pour 1 000 habitants**. Rapport restaurants rapides / commerces favorables : 6 / 3 = **2,0**.
2. Il s'agit d'un **marais alimentaire** : l'offre est abondante (le quartier est « bien commerçant »), mais les commerces défavorables sont plus de trois fois plus nombreux que les commerces favorables (10 contre 3). Ce n'est pas un désert, puisque des produits frais existent à proximité.
3. Budget : 180 / 2 / 30 = **3,00 € par personne et par jour**. Un panier de base représente 18,05 / 180 × 100 = **10,0 %** du budget mensuel à la supérette et 12,85 / 180 × 100 = **7,1 %** au supermarché. Le prix de l'offre de proximité pèse lourdement sur un budget déjà serré.
4. Le repérage ne compte que le nombre de commerces, pas leur taille ni les produits réellement achetés ; c'est un instantané (horaires, saison) ; le marché n'a lieu qu'une fois par semaine ; le rayon de 800 m ne correspond pas forcément aux trajets des habitants.
5. Exemples : proposer à la mairie un deuxième marché, le samedi, ou un étal de fruits et légumes à prix solidaires ; négocier avec la supérette un rayon de produits de base à prix maîtrisés ; mettre en place une commande groupée mensuelle au supermarché ; plaider auprès de la commune pour limiter les nouveaux restaurants rapides près des écoles (plan local d'urbanisme).

Corrigé – Exercice 7.28

1. Questionnaire : 153 / 212 × 100 = **72,2 %** des élèves déclarent manger les légumes presque tous les jours. Observation : 342 / 600 × 100 = **57,0 %** des plateaux reviennent avec la portion de légumes entière ou presque.
2. Désirabilité sociale : en classe, devant un adulte, les élèves déclarent ce qui semble « bien ». Différence de mesure : le questionnaire porte sur l'élève, l'observation porte sur le plateau (un élève peut manger les frites mais pas les haricots) ; « presque tous les jours » est vague ; les jours observés ne sont peut-être pas représentatifs (menu, météo). Biais de mémoire possible. Il n'y a donc pas forcément contradiction : les deux sources ne mesurent pas exactement la même chose.
3. L'entretien apporte une explication (types de légumes appréciés ou non, temps de repas de 25 minutes) et le point de vue d'un professionnel de terrain. Limites : c'est un seul avis, général (« les légumes partent à la poubelle »), qui peut être influencé par la lassitude ou la défense de son travail.
4. Exemple : « Les élèves déclarent majoritairement manger les légumes (72 %), mais l'observation montre que plus de la moitié des portions reviennent intactes (57 % des plateaux), surtout pour les légumes autres que les frites et le maïs selon le chef. La consommation réelle de légumes au restaurant scolaire est donc probablement faible, dans un temps de repas court. »
5. Exemples : la pesée des restes par catégorie de plat sur une semaine (gaspillage) ; un groupe de parole avec des élèves ; l'analyse des menus (fréquence et types de légumes, préparation) ; la mesure du temps réellement passé à table.

Corrigé – Exercice 7.29

1. Écart absolu : 21,4 − 9,8 = **11,6 points**. Rapport : 21,4 / 9,8 = **2,18** : le surpoids est un peu plus de deux fois plus fréquent dans les communes les plus pauvres que dans les plus aisées.
2. La fréquence du surpoids diminue régulièrement d'un quintile à l'autre, du plus pauvre au plus aisé : c'est un **gradient social**. Il ne s'agit pas d'un problème limité aux plus pauvres.
3. Moyenne simple : (21,4 + 18,0 + 15,2 + 12,6 + 9,8) / 5 = 77,0 / 5 = **15,4 %**. Deux quintiles sont au-dessus (Q1, Q2), trois au-dessous (Q3, Q4, Q5), dont Q3 très proche de la moyenne.
4. Le gradient montre que le risque augmente à chaque échelon : les quintiles Q2 et Q3 ont aussi des fréquences élevées (18,0 % et 15,2 %) et rassemblent beaucoup d'enfants. Une action réservée à Q1 laisserait de côté la majorité des enfants concernés et pourrait stigmatiser les communes ciblées. L'**universalisme proportionné** (Marmot, 2010) propose des actions pour tous, avec une intensité et des moyens proportionnés au niveau de besoin, pour réduire le gradient sans abandonner personne.
5. Exemple : proposer à toutes les écoles un socle commun (deux ateliers par classe et un kit pour les familles), renforcé dans les écoles des quintiles Q1 et Q2 (cycle de six ateliers, ateliers parents-enfants, goûters partagés, interventions de la diététicienne), avec une évaluation qui suit l'évolution de l'écart entre quintiles.

Corrigé – Exercice 7.30

1. Sans rien avoir mangé : 15 / 24 = **62,5 %**. Sans cuisine équipée : 11 / 24 = **45,8 %**. Moins de 5 € par jour : 9 / 24 = **37,5 %**. Légumes tous les jours : 6 / 24 = **25,0 %**. Souhaitent emporter des légumes : 18 / 24 = **75,0 %**. (Avec 24 personnes, on peut donner les deux formes : « 15 sur 24 ».)
2. Les salariés produisent chaque semaine des légumes, dont environ 40 kg sont compostés faute de calibre, mais seuls 6 sur 24 en mangent tous les jours : l'offre est sur place, mais elle n'arrive pas dans leur assiette.
3. Normatif : 18 salariés sur 24 ne mangent pas de légumes tous les jours, alors que les repères recommandent au moins cinq fruits et légumes par jour ; 15 sur 24 commencent leur journée de travail physique à jeun. Ressenti : fatigue observée par l'encadrante ; « je n'en mange jamais ». Exprimé : 18 sur 24 demandent à emporter des légumes. Comparatif : non disponible ici (on pourrait comparer avec

d'autres chantiers ou avec les données nationales).

4. Exemple : « Les salariés du chantier d'insertion ont une alimentation insuffisante pendant la journée de travail : 15 sur 24 arrivent sans avoir rien mangé et seuls 6 sur 24 mangent des légumes tous les jours, alors qu'ils produisent des légumes biologiques dont une partie est compostée. Plusieurs causes se cumulent : des horaires de transport très matinaux, l'absence de cuisine équipée chez près de la moitié des salariés (11 sur 24), un budget alimentaire très faible pour plus d'un tiers (9 sur 24) et l'absence d'organisation pour utiliser les légumes non calibrés. Les conséquences observées sont des coups de fatigue en fin de matinée, qui peuvent gêner le travail physique et la sécurité ; les liens précis restent à confirmer. Le chantier dispose de ressources importantes : la production de légumes, une salle de pause équipée d'un réfrigérateur et d'un four à micro-ondes, et une forte demande des salariés. »

5. Exemples : organiser une collation partagée à l'arrivée (pain, fruits, laitages) avec un budget dédié ; distribuer chaque semaine les légumes non calibrés, accompagnés de recettes réalisables au four à micro-ondes ou avec une plaque ; animer quelques ateliers de cuisine dans la salle de pause.

Partie 6 – Définir les priorités

Objectifs – Objectifs de la partie

- Utiliser des critères explicites pour choisir des priorités.
- Calculer un score de priorité de Hanlon et appliquer le test PEARL.
- Animer et dépouiller une technique du groupe nominal.
- Choisir une méthode participative adaptée au public.
- Construire une matrice FFOM croisée et arbitrer en comité de pilotage.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Critères de priorité : ampleur, gravité, efficacité des interventions, faisabilité, acceptabilité, cohérence avec les politiques (PNNS, PRS, CLS), équité.
- Méthode de Hanlon (version du cours) : A = ampleur, B = gravité, C = efficacité, notés de 0 à 10 ; score = (A + 2B) × C / 3, sur 100 au plus.
- Test PEARL : Pertinence, Économie, Acceptabilité, Ressources, Légalité ; chaque critère vaut 1 ou 0 ; un seul 0 écarte le problème, quel que soit son score.
- Un problème écarté n'est pas abandonné : on oriente vers un partenaire, on transmet au CLS, on fait du plaidoyer.
- Technique du groupe nominal : production individuelle silencieuse, tour de table, clarification, vote individuel pondéré, dépouillement collectif.
- Matrice FFOM croisée : forces × opportunités (stratégie offensive) ; faiblesses × opportunités (amélioration) ; forces × menaces (défensive) ; faiblesses × menaces (survie).

Exercice 7.31 – Les critères de priorité (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une réunion de comité de pilotage dans une maison de santé pluriprofessionnelle (fictive), chacun défend « son » problème. Vous notez les arguments entendus.

Document 1 – Huit arguments entendus

a) « Ce problème touche un patient sur trois. »

b) « Il entraîne des hospitalisations évitables. »

c) « Des actions de ce type ont fait leurs preuves ailleurs. »

d) « Nous avons la salle, l'infirmière et le temps pour le faire. »

e) « Les patients nous le demandent depuis deux ans. »

f) « C'est un axe du projet régional de santé, avec un appel à projets. »

g) « Ce sont les patients les plus précaires qui sont le plus touchés. »

h) « Il faut agir vite : la situation se dégrade chaque mois. »

À vous de jouer – Questions

1. Citez les sept critères de priorité et la question associée à chacun. (4 pts)

2. Associez chaque argument du document 1 à un critère. (4 pts)

3. Expliquez pourquoi le jury attend des critères explicites plutôt qu'un choix « au feeling ». (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.32 – Calculer des scores de Hanlon (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – calcul guidé · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre du contrat local de santé de la ville de Rocheval (fictive), le groupe de travail « nutrition » a noté cinq problèmes issus du diagnostic.

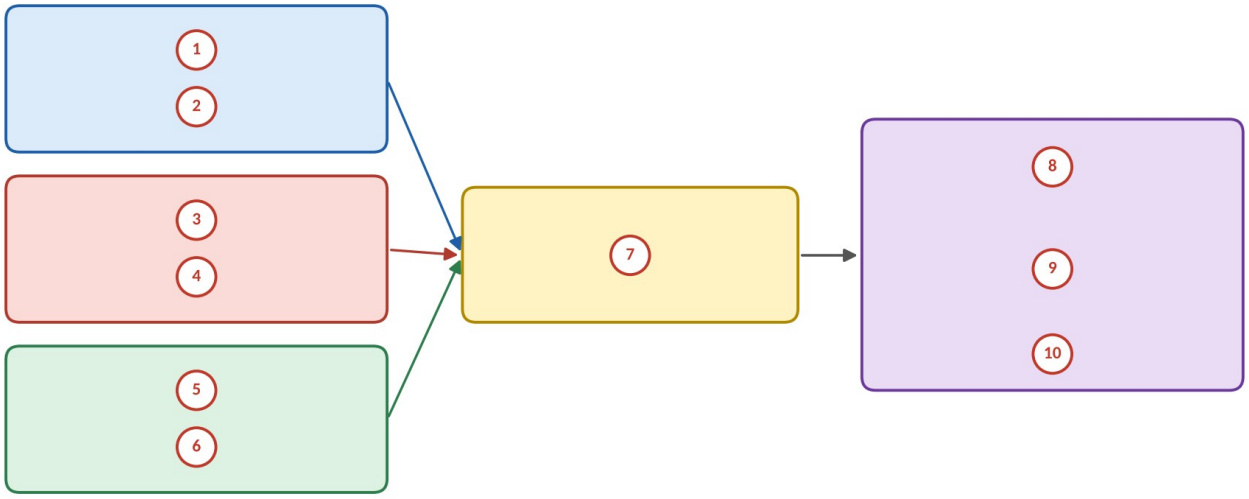


Figure 7.9 – Document 1 – Hiérarchiser les problèmes : score de Hanlon et test PEARL (schéma à légender)

Document 2 – Notes attribuées par le groupe de travail (de 0 à 10)

Problème	A (ampleur)	B (gravité)	C (efficacité)
P1 – Boissons sucrées quotidiennes chez les adolescents	6	5	7
P2 – Petit déjeuner sauté par les collégiens	7	6	6
P3 – Surpoids des enfants de 6 à 11 ans	4	7	4
P4 – Faible consommation de légumes dans les familles	8	5	6
P5 – Dénutrition des aînés isolés à domicile	2	9	7

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (3 pts)
2. Calculez le score de Hanlon de chaque problème, en détaillant le calcul de P5. (5 pts)
3. Classez les cinq problèmes. (1 pt)
4. Expliquez pourquoi P5 arrive en tête alors qu'il touche peu de personnes. (2 pts)
5. Indiquez la principale limite de cette méthode. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.33 – Le test PEARL et la décision (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le projet de l'exercice 7.32 est porté par le service jeunesse de la ville, qui dispose d'un budget de 6 000 €, d'une animatrice et d'une diététicienne vacataire. Le groupe applique le test PEARL aux cinq problèmes.

Document 1 – Informations pour le test PEARL

- P1 : le service jeunesse peut agir dans les accueils de jeunes ; une action « eau et boissons » coûte environ 1 500 €.
- P2 : les deux collèges sont partenaires ; un petit déjeuner pédagogique par classe de 6e coûte environ 2 400 € par an.
- P3 : les parents interrogés refusent toute pesée ou action « centrée sur le poids » à l'école ; le médecin scolaire est déjà mobilisé sur ce sujet.
- P4 : les ateliers cuisine parents-enfants sont dans la mission du service jeunesse ; budget environ 3 000 €.
- P5 : les aînés ne relèvent pas du service jeunesse ; le CCAS prépare une action avec le portage de repas.

À vous de jouer – Questions

1. Appliquez le test PEARL aux cinq problèmes, sous forme de tableau, et justifiez chaque 0. (5 pts)

2. Indiquez les problèmes retenus et vérifiez que le budget permet de les traiter. (3 pts)

3. Expliquez ce que deviennent les problèmes écartés. (2 pts)

4. Les scores de P1, P2 et P4 sont proches. Proposez un argument complémentaire pour arbitrer. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.34 – Dépouiller un groupe nominal (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et méthode · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez, avec le conseil citoyen du quartier des Bruyères (fictif), une technique du groupe nominal sur la question : « Que faudrait-il faire pour mieux manger dans le quartier ? ». Après la production et la clarification, il reste huit propositions. Chacun des neuf participants choisit cinq propositions et leur attribue 5, 4, 3, 2 et 1 point (5 pour sa préférée).

Document 1 – Les huit propositions

A : un marché de producteurs le samedi ; B : des ateliers cuisine parents-enfants ; C : un jardin partagé ; D : un petit déjeuner à l'école ; E : des affiches d'information ; F : un concours de recettes ; G : un livret de recettes à petit prix ; H : des séances de sport en plein air.

Document 2 – Bulletins (dans l'ordre, la proposition qui reçoit 5 points, puis 4, 3, 2 et 1)

Participant	5 points	4 points	3 points	2 points	1 point
1	A	B	D	C	E
2	B	A	E	D	G
3	A	D	B	H	C
4	B	C	A	E	F
5	D	B	A	G	H
6	A	C	D	B	E
7	H	B	D	A	C
8	G	E	D	B	A
9	F	A	H	D	B

À vous de jouer – Questions

1. Rappelez les cinq étapes de la technique du groupe nominal. (2,5 pts)
2. Calculez pour chaque proposition le total des points, le nombre de participants qui l'ont choisie et le nombre de premières places. Vérifiez le total général. (5 pts)
3. Établissez le classement et commentez les deux premières propositions. (2,5 pts)
4. Indiquez deux avantages de cette méthode par rapport à un débat libre. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.35 – Choisir une méthode participative (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous devez associer le public au diagnostic dans trois situations différentes. Votre tutrice vous demande de choisir la méthode la plus adaptée à chacune.

Document 1 – Trois situations

- Situation 1 : 12 personnes âgées d'une résidence autonomie, dont plusieurs ont des troubles de la vue, souhaitent dire ce qui rend le repas agréable ou non.
- Situation 2 : 40 habitants d'un quartier et des professionnels (commerçants, travailleurs sociaux) doivent produire des idées sur l'accès aux produits frais, en une soirée.
- Situation 3 : 8 jeunes d'un dispositif d'insertion, peu à l'aise à l'écrit, doivent dire ce que représente pour eux « bien manger ».

Document 2 – Méthodes possibles

Photolangage ; world café (tables de 4 à 6 personnes, plusieurs tours, un hôte par table) ; marche exploratoire (parcours collectif du quartier avec une grille d'observation) ; groupe de parole ; technique du groupe nominal.

À vous de jouer – Questions

1. Choisissez une méthode pour chaque situation et justifiez par les caractéristiques du public. (6 pts)

2. Décrivez le déroulement de la méthode choisie pour la situation 2, avec la durée de chaque étape. (4 pts)

3. Indiquez deux précautions communes à toutes les méthodes participatives. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

……

……

Exercice 7.36 – Arbitrer en comité de pilotage avec la matrice FFOM croisée (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association « Familles en Bocage » (fictive) gère un espace de vie sociale dans une commune rurale. Le diagnostic a fait ressortir deux priorités : la faible consommation de légumes et de légumes secs, et l'isolement des familles. Le comité de pilotage doit choisir une stratégie.

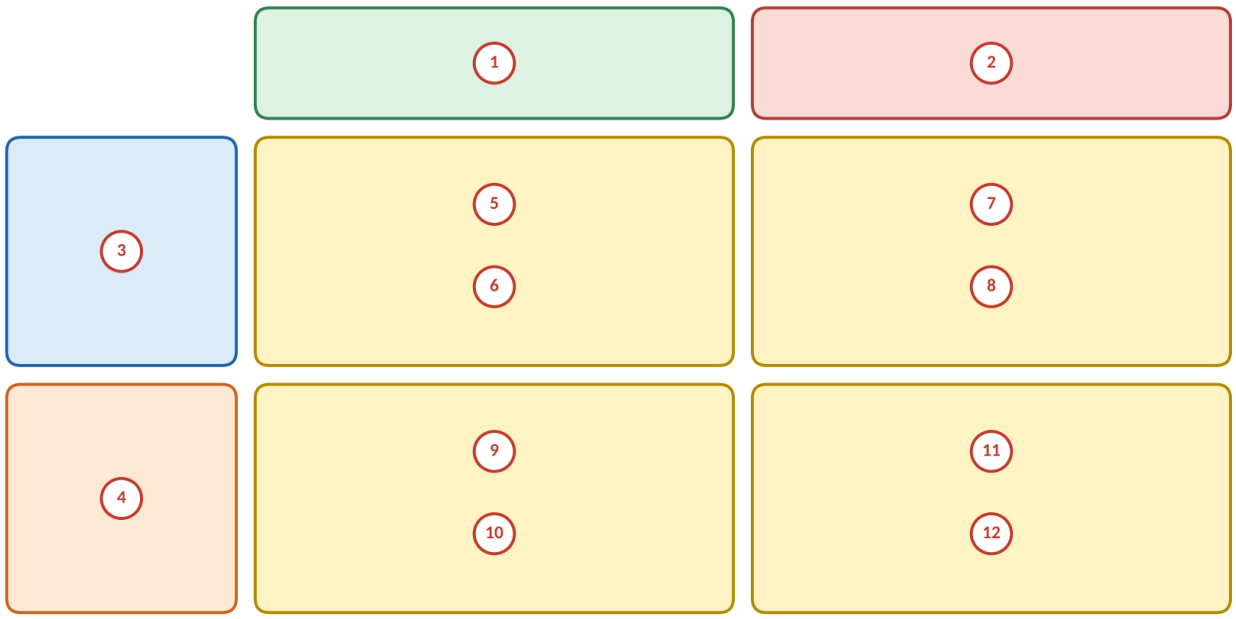


Figure 7.10 – Document 1 – La matrice FFOM croisée (schéma à légender)

Document 2 – Éléments de l'analyse FFOM

- Forces : une salle avec cuisine équipée ; deux bénévoles anciennes cuisinières ; 35 familles qui fréquentent déjà l'espace.
- Faiblesses : pas de salarié le samedi ; pas de véhicule ; peu de familles avec de jeunes enfants.
- Opportunités : appel à projets du projet alimentaire territorial (PAT) ; maraîcher bio volontaire à 3 km ; PMI qui cherche un lieu pour des ateliers.
- Menaces : hausse des prix alimentaires ; transport scolaire qui ne passe pas le mercredi ; une autre association propose des ateliers payants dans la commune voisine.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (3 pts)

2. Construisez la matrice FFOM croisée avec une stratégie concrète dans chaque case. (6 pts)

3. Proposez au comité la stratégie principale et justifiez-la au regard des deux priorités. (3 pts)

4. Rédigez le relevé de décision du comité de pilotage en cinq lignes (décision, raisons, suite). (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 7.31

1. Ampleur : combien de personnes sont concernées ? Gravité : quelles conséquences, quelle urgence ? Efficacité de l'intervention : existe-t-il des actions efficaces ? Faisabilité : la structure a-t-elle les moyens, les compétences, le temps ? Acceptabilité : le public et les partenaires sont-ils demandeurs ? Cohérence politique : le problème est-il une priorité du PNNS, du PRS, du CLS ? Équité : le projet réduit-il les inégalités ?
2. a) ampleur ; b) gravité ; c) efficacité ; d) faisabilité ; e) acceptabilité (besoin exprimé) ; f) cohérence politique ; g) équité ; h) gravité (urgence).
3. Des critères explicites rendent le choix transparent, discutable et reproductible ; ils protègent contre l'influence de la personne qui parle le plus fort ; ils permettent de justifier le projet auprès des financeurs et du jury, et de revenir sur la décision si la situation change.

Corrigé – Exercice 7.32

1. Légendes : 1 A = ampleur ; 2 nombre de personnes touchées (0 à 10) ; 3 B = gravité ; 4 conséquences, urgence (0 à 10), compte double ; 5 C = efficacité ; 6 actions efficaces disponibles (0 à 10) ; 7 Score = (A + 2B) × C / 3 ; 8 Test PEARL ; 9 Pertinence, Économie, Acceptabilité, Ressources, Légalité ; 10 un seul « non » écarte le problème.
2. P5 : 2B = 2 × 9 = 18 ; A + 2B = 2 + 18 = 20 ; 20 × 7 = 140 ; 140 / 3 = **46,7**. P1 : (6 + 10) × 7 / 3 = 112 / 3 = **37,3**. P2 : (7 + 12) × 6 / 3 = 114 / 3 = **38,0**. P3 : (4 + 14) × 4 / 3 = 72 / 3 = **24,0**. P4 : (8 + 10) × 6 / 3 = 108 / 3 = **36,0**.
3. P5 (46,7) > P2 (38,0) > P1 (37,3) > P4 (36,0) > P3 (24,0).
4. La gravité compte double : la dénutrition des personnes âgées a des conséquences graves (chutes, hospitalisations, perte d'autonomie), notée 9 sur 10, et les actions sont jugées efficaces (7). Ce poids compense la faible ampleur (2).
5. Les notes sont subjectives : elles dépendent des personnes du groupe. Leur intérêt est de rendre le raisonnement transparent ; on les justifie par les faits du diagnostic et on les attribue collectivement.

Corrigé – Exercice 7.33

1. Tableau :

Problème	P	É	A	R	L	Décision
P1	1	1	1	1	1	retenu (37,3)
P2	1	1	1	1	1	retenu (38,0)
P3	1	1	0	0	1	écarté
P4	1	1	1	1	1	retenu (36,0)
P5	0	1	1	0	1	écarté

P3 : acceptabilité 0, les parents refusent une action centrée sur le poids ; ressources 0, le sujet est déjà porté par le médecin scolaire. P5 : pertinence 0, les aînés ne relèvent pas de la mission du service jeunesse ; ressources 0, le service n'a pas les moyens d'intervenir à domicile.

2. Problèmes retenus : P2, P1 et P4. Coûts : 2 400 + 1 500 + 3 000 = **6 900 €**, ce qui dépasse le budget de 6 000 € de 900 €. Il faut soit traiter deux problèmes en totalité (par exemple P2 et P4 : 5 400 €, marge 600 €), soit combiner P1 et P2 dans une même action (petit déjeuner pédagogique avec un volet « eau et boissons »), soit chercher un cofinancement.
3. P5 est transmis au CCAS, qui prépare une action avec le portage de repas, et au CLS ; le service jeunesse peut soutenir l'action (intergénérationnel). P3 reste suivi par le médecin scolaire ; le projet n'en parle pas

sous l'angle du poids, mais les actions sur les boissons, le petit déjeuner et les légumes y contribuent indirectement.

4. Exemples : l'équité (quel problème touche le plus les jeunes des quartiers prioritaires ?) ; la demande des jeunes et des familles ; la possibilité de combiner les actions (P1 et P2 au petit déjeuner) ; l'existence d'interventions probantes répertoriées par Santé publique France.

Corrigé – Exercice 7.34

1. Production individuelle et silencieuse des idées ; tour de table où chacun énonce une idée à la fois, notée au tableau sans discussion ; clarification et regroupement des idées ; vote individuel et pondéré ; dépouillement collectif et discussion du résultat.

2. A : 5 + 4 + 5 + 3 + 3 + 5 + 2 + 1 + 4 = **32 points**, 9 participants, 3 premières places. B : 4 + 5 + 3 + 5 + 4 + 2 + 4 + 2 + 1 = **30 points**, 9 participants, 2 premières places. C : 2 + 1 + 4 + 4 + 1 = **12 points**, 5 participants, aucune première place. D : 3 + 2 + 4 + 5 + 3 + 3 + 3 + 2 = **25 points**, 8 participants, 1 première place. E : 1 + 3 + 2 + 1 + 4 = **11 points**, 5 participants. F : 1 + 5 = **6 points**, 2 participants, 1 première place. G : 1 + 2 + 5 = **8 points**, 3 participants, 1 première place. H : 2 + 1 + 5 + 3 = **11 points**, 4 participants, 1 première place. Total : 32 + 30 + 12 + 25 + 11 + 6 + 8 + 11 = **135 points**, égal à 9 participants × (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 9 × 15 = 135.

3. Classement : A (32), B (30), D (25), C (12), E et H (11), G (8), F (6). Le marché de producteurs et les ateliers parents-enfants sont choisis par les neuf participants et arrivent nettement en tête : ils font consensus. Le petit déjeuner à l'école suit (25 points, 8 participants). Les autres propositions sont soutenues par une minorité, parfois avec conviction (F, G et H ont chacune une première place).

4. Chacun s'exprime, y compris les personnes timides, et les idées ne sont pas captées par quelques participants ; le résultat est chiffré, visible et accepté par le groupe ; la méthode est rapide et produit une liste hiérarchisée.

Corrigé – Exercice 7.35

1. Situation 1 : groupe de parole en petit comité, animé à l'oral, éventuellement autour d'un repas ou d'objets à toucher et à sentir ; le photolangage est peu adapté aux troubles de la vue. Situation 2 : world café, qui permet de faire travailler 40 personnes en petits groupes, de croiser les regards des habitants et des professionnels et de produire beaucoup d'idées en une soirée. Situation 3 : photolangage, qui passe par l'image et la parole et non par l'écrit ; il facilite l'expression des représentations.

2. World café (2 h) : accueil, présentation de la question et des règles (10 min) ; trois tours de 20 minutes à des tables de 5 ou 6 personnes, sur trois sous-questions (où acheter ? à quel prix ? comment s'y rendre ?), avec un hôte qui reste à sa table et résume le tour précédent aux nouveaux arrivants (60 min) ; restitution des hôtes en grand groupe (20 min) ; vote par gommettes sur les idées à approfondir (15 min) ; conclusion et suite donnée (15 min).

3. Expliquer le but, la durée et l'usage des résultats ; garantir la liberté de participer et la confidentialité des propos ; adapter le langage et le support ; restituer les résultats aux participants ; ne pas promettre ce que la structure ne pourra pas faire.

Corrigé – Exercice 7.36

1. Légendes : 1 Opportunités (externes) ; 2 Menaces (externes) ; 3 Forces (internes) ; 4 Faiblesses (internes) ; 5 Stratégie offensive ; 6 utiliser les forces pour saisir les opportunités ; 7 Stratégie défensive ; 8 utiliser les forces pour limiter les menaces ; 9 Stratégie d'amélioration ; 10 saisir les opportunités pour corriger les faiblesses ; 11 Stratégie de survie ; 12 réduire la vulnérabilité face aux menaces.

2. Offensive (forces × opportunités) : répondre à l'appel à projets du PAT avec des ateliers cuisine de légumes et légumes secs dans la cuisine équipée, animés par les bénévoles, avec les légumes du maraîcher. Amélioration (faiblesses × opportunités) : accueillir les ateliers de la PMI pour toucher les familles avec de

jeunes enfants ; financer par le PAT un temps de salarié le samedi. Défensive (forces × menaces) : proposer des recettes très économiques face à la hausse des prix ; garder des ateliers gratuits, différents de l'offre payante voisine. Survie (faiblesses × menaces) : organiser un covoiturage entre familles pour les ateliers du mercredi ; diversifier les financeurs pour ne pas dépendre d'un seul appel à projets.

3. Stratégie principale : l'offensive, complétée par l'amélioration. Elle répond aux deux priorités en même temps : les ateliers cuisine collectifs augmentent les compétences autour des légumes et légumes secs et créent du lien entre familles (isolement). Elle s'appuie sur les forces existantes et sur un financement disponible, et le partenariat avec la PMI corrige la faiblesse principale (peu de jeunes familles).

4. Exemple : « Le comité de pilotage du [date] décide de déposer un projet à l'appel à projets du PAT : un cycle d'ateliers cuisine “légumes et légumes secs” dans la salle de l'espace de vie sociale, avec le maraîcher partenaire et la PMI. Ce choix répond aux deux priorités du diagnostic et s'appuie sur la cuisine équipée et les bénévoles. Un covoiturage sera organisé pour les familles sans véhicule. L'étudiante rédige les objectifs et le budget pour la prochaine réunion, le [date]. »

Partie 7 – Problématique et objectifs

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer objectif général, objectifs spécifiques et objectifs opérationnels.
- Reformuler un objectif pour qu'il soit SMART, avec un verbe observable.
- Calculer une valeur cible en effectif et en pourcentage.
- Transformer un arbre à problèmes en arbre à objectifs.
- Formuler une problématique cohérente avec le diagnostic.
- Associer à chaque objectif un indicateur, une source de vérification et une échéance.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Objectif général : but à long terme auquel le projet contribue, souvent repris d'une politique ; il n'est pas mesuré par le seul projet.
- Objectifs spécifiques : changements attendus chez le public ou dans son environnement (connaissances, compétences, attitudes, comportements, accès) ; ils répondent aux causes retenues ; ils sont SMART.
- Objectifs opérationnels : ce que l'équipe réalise (ateliers, supports, partenariats) ; SMART ; ils servent à l'évaluation du processus. Lecture de haut en bas : « comment ? » ; de bas en haut : « pourquoi ? ».
- SMART : spécifique, mesurable (indicateur et valeur cible), atteignable, réaliste et pertinent, temporellement défini.
- Verbes observables : citer, classer, calculer, préparer, choisir, consommer, proposer ; à éviter : savoir, comprendre, prendre conscience, sensibiliser.
- Valeur cible en effectif : pourcentage × effectif, arrondi à l'entier supérieur pour une cible « au moins », à l'entier inférieur pour une cible « au plus ».
- Problématique : question ouverte (« Comment… ? », « En quoi… ? ») qui part du constat, exprime une tension et précise le public, le lieu et le levier.

Exercice 7.37 – La hiérarchie des objectifs (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice a écrit neuf objectifs en vrac pour un projet « cuisine et budget » dans une résidence sociale (fictive). Elle vous demande de les ranger.

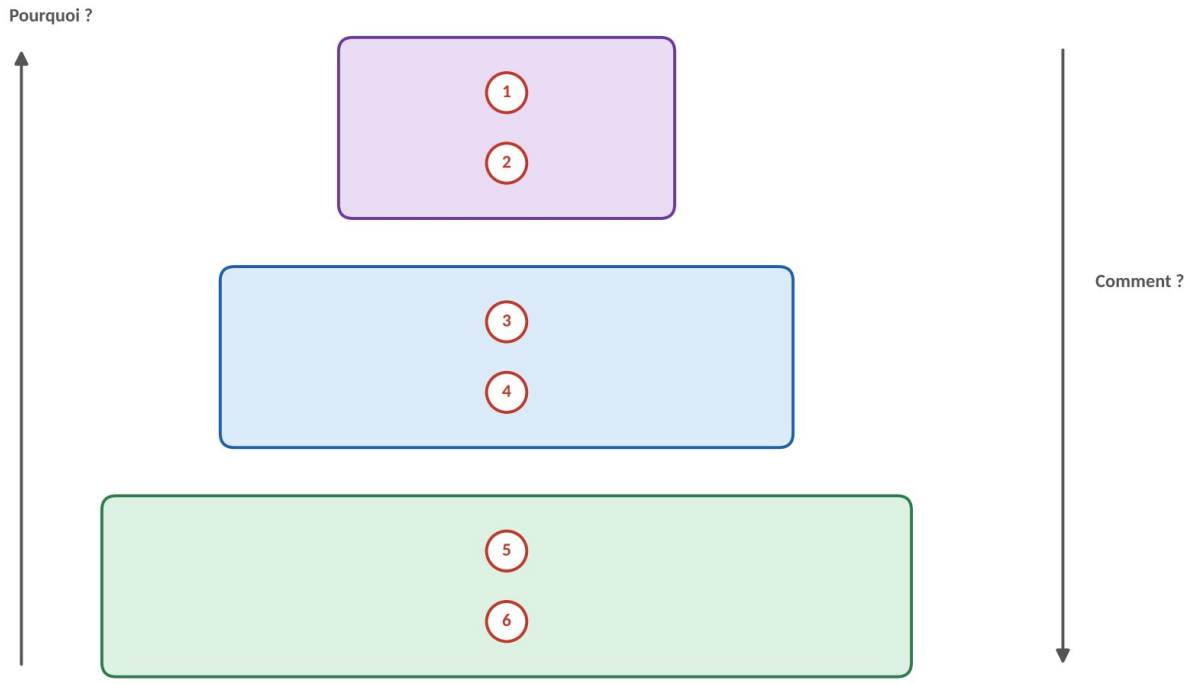


Figure 7.11 – Document 1 – La hiérarchie des objectifs (schéma à légender)

Document 2 – Neuf objectifs

a) Contribuer à améliorer l'alimentation des résidents de la résidence sociale.

b) Animer 6 ateliers cuisine de 2 heures entre janvier et mars 2027.

c) D'ici fin mars 2027, au moins 10 des 22 résidents inscrits préparent un repas chaud au moins trois fois par semaine.

d) Réaliser un livret de 15 recettes à moins de 1,50 € la portion avant le 15 février 2027.

e) À la fin du cycle, au moins 15 des 22 inscrits calculent correctement le coût d'une portion à partir d'un ticket de caisse.

f) Établir une convention avec l'épicerie solidaire voisine avant décembre 2026.

g) D'ici juin 2027, la moitié des résidents inscrits achètent des légumes secs au moins une fois par mois.

h) Organiser un repas partagé mensuel dans la salle commune de janvier à juin 2027.

i) D'ici fin mars 2027, au moins 12 des 22 inscrits déclarent manger avec d'autres résidents au moins une fois par semaine.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Classez les neuf objectifs du document 2 en objectif général, objectifs spécifiques et objectifs opérationnels. (4,5 pts)

3. Reliez chaque objectif opérationnel à l'objectif spécifique qu'il sert. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.38 – Rendre un objectif SMART (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le dossier de demande de subvention d'une association sportive (fictive) contient des objectifs mal rédigés. Le financeur les a refusés en écrivant : « Objectifs non évaluables. »

Document 1 – Six objectifs refusés

a) « Sensibiliser les jeunes à l'importance de l'hydratation. »

b) « Que les adhérents mangent mieux. »

c) « Faire des ateliers. »

d) « Faire prendre conscience aux parents que les boissons énergisantes sont dangereuses. »

e) « Améliorer les connaissances nutritionnelles des entraîneurs. »

f) « Réduire l'obésité dans le club. »

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi chaque objectif du document 1 n'est pas évaluable. (3 pts)
2. Réécrivez chaque objectif sous une forme SMART (vous inventerez des valeurs réalistes, en précisant qu'elles sont fictives). (6 pts)
3. Pour l'objectif f), expliquez pourquoi il vaut mieux le transformer que le reformuler. (2 pts)
4. Classez vos six objectifs reformulés en spécifiques ou opérationnels. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.39 – Calculer des valeurs cibles (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – calcul · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous fixez les valeurs cibles de trois projets à partir des données du diagnostic.

Document 1 – Trois projets (données fictives)

- Projet 1 : cycle de 8 ateliers pour 14 parents. Objectif spécifique : au moins 60 % des parents servent un légume à chaque dîner à la fin du cycle. Objectif opérationnel : taux de présence d'au moins 80 %.
- Projet 2 : foyer de 46 résidents. Objectif : au moins 75 % des résidents citent trois repères de consommation à la fin de l'année.
- Projet 3 : 120 élèves de 6e ; 38 % apportent une boisson sucrée au collège. Objectif : 25 % au plus à la fin de l'année scolaire.

À vous de jouer – Questions

1. Projet 1 : calculez le nombre de parents visés et le nombre de présences attendu. (3 pts)

2. Projet 2 : calculez le nombre de résidents visés. (1 pt)

3. Projet 3 : calculez le nombre d'élèves concernés au départ et le nombre maximal visé, l'écart en points et la variation relative. (4 pts)

4. Expliquez la règle d'arrondi d'une valeur cible. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.40 – De l'arbre à problèmes à l'arbre à objectifs (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous reprenez le diagnostic de Montclar-sur-Aune (exercice 7.26) : 25 des 41 personnes de 70 ans et plus vivant seules mangent de la viande, du poisson ou des œufs moins d'une fois par jour. Le CCAS dispose d'un budget de 4 000 € et d'une salle des fêtes équipée d'une cuisine.

Document 1 – Causes du problème central

- C1 : absence d'épicerie et transports limités (17 personnes sans voiture).
- C2 : perte d'envie de cuisiner pour soi seul (22 personnes).
- C3 : difficultés de mastication (9 personnes).
- C4 : isolement (15 personnes se sentent seules souvent ou toujours).
- C5 : coût du portage de repas (9,20 € le repas).

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez comment on transforme un arbre à problèmes en arbre à objectifs. (2 pts)
2. Formulez l'objectif général. (1 pt)
3. Transformez chaque cause en objectif spécifique, puis indiquez les causes que le CCAS retient et celles qu'il transmet à d'autres acteurs, avec la raison. (5 pts)
4. Rédigez deux objectifs spécifiques SMART pour les causes retenues, avec leur valeur cible. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.41 – Formuler une problématique (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse et rédaction · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Trois étudiants de votre promotion vous soumettent la problématique de leur dossier de projet. Vous les aidez à les améliorer, puis vous rédigez celle du chantier d'insertion de l'exercice 7.30.

Document 1 – Trois problématiques proposées

a) « Les jeunes du foyer mangent-ils trop de sucre ? »

b) « Comment lutter contre la malbouffe ? »

c) « Pourquoi mettre en place un atelier cuisine à la maison de quartier ? »

À vous de jouer – Questions

1. Rappelez les quatre étapes de construction d'une problématique. (2 pts)
2. Expliquez le défaut de chaque problématique du document 1 et proposez une version améliorée (vous pouvez inventer un contexte simple). (6 pts)
3. Rédigez la problématique du chantier d'insertion « Les Jardins du Pont-Vieux » (exercice 7.30). (2 pts)
4. Montrez la cohérence entre le problème central, la problématique et l'objectif général de ce chantier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.42 – Construire le cadre logique d'un projet (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous reprenez le foyer d'hébergement « Les Glycines » (exercice 7.6). Le diagnostic, complété par l'observation des repas, a été validé : 27 résidents sur 46 achètent chaque jour des produits sucrés au distributeur ; le dimanche, les repas sont toujours des plats surgelés ; les résidents demandent à apprendre à cuisiner. Le département finance un projet d'un an (budget fictif de 5 000 €).

À vous de jouer – Questions

1. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et quatre objectifs opérationnels SMART (deux par objectif spécifique). (6 pts)
2. Présentez sous forme de tableau, pour chaque objectif spécifique et opérationnel : l'indicateur, la valeur de départ, la valeur cible, la source de vérification et l'échéance. (6 pts)
3. Indiquez deux hypothèses (conditions extérieures) nécessaires à la réussite et deux risques, avec une mesure pour chacun. (2 pts)
4. Vérifiez votre cadre logique avec les questions « comment ? » et « pourquoi ? ». (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 7.37

1. Légendes : 1 Objectif général ; 2 but à long terme auquel le projet contribue ; 3 Objectifs spécifiques ; 4 changements attendus chez le public, SMART ; 5 Objectifs opérationnels ; 6 ce que l'équipe réalise, SMART.

2. Objectif général : a). Objectifs spécifiques (changements chez les résidents) : c), e), g), i). Objectifs opérationnels (ce que fait l'équipe) : b), d), f), h).

3. b) ateliers → c) et e) ; d) livret → c) et e) ; f) convention avec l'épicerie → g) ; h) repas partagé → i).

Corrigé – Exercice 7.38

1. a) « Sensibiliser » n'est pas observable, pas de valeur cible ni d'échéance. b) Vague (« mieux »), pas d'indicateur. c) Action sans nombre, ni public, ni date. d) « Prendre conscience » n'est pas observable ; le message « dangereuses » est discutable et peu nuancé. e) « Améliorer » sans mesure ni échéance. f) Objectif centré sur le poids, mesuré par la pesée, hors de portée d'un projet associatif et potentiellement stigmatisant.

2. Exemples (valeurs fictives) : a) « À la fin de la saison 2026-2027, au moins 70 % des jeunes de 12 à 15 ans du club apportent une gourde d'eau à chaque entraînement (observation de 4 séances par trimestre). » b) « D'ici juin 2027, au moins 60 % des adhérents de 14 à 17 ans prennent une collation à base de fruit ou de produit laitier avant l'entraînement du soir (questionnaire avant-après). » c) « Animer 4 ateliers “collations du sportif” d'une heure pour les 45 adhérents de 12 à 17 ans entre octobre 2026 et mars 2027. » d) « À la fin de la réunion de rentrée, au moins 80 % des parents présents citent deux effets des boissons énergisantes chez l'adolescent et une boisson de remplacement (questionnaire de sortie). » e) « D'ici décembre 2026, les 6 entraîneurs obtiennent au moins 7 sur 10 à un quiz sur l'hydratation et les collations, après une formation de 2 heures. » f) voir question 3.

3. La corpulence dépend de nombreux facteurs que le club ne maîtrise pas ; la mesurer suppose des pesées, qui peuvent stigmatiser les jeunes. On transforme l'objectif en changements de comportements et d'environnement à la portée du club : collations, hydratation, offre de la buvette, plaisir de l'activité physique. Exemple : « D'ici juin 2027, la buvette du club propose de l'eau et des fruits à chaque match, et les boissons sucrées représentent moins de 30 % des ventes (relevé des ventes). »

4. Spécifiques : a), b), d), e), f) transformé. Opérationnel : c).

Corrigé – Exercice 7.39

1. Parents visés : 0,60 × 14 = 8,4, soit **9 parents** au moins. Présences possibles : 8 × 14 = 112 ; cible : 0,80 × 112 = 89,6, soit **90 présences** au moins.

2. 0,75 × 46 = 34,5, soit **35 résidents** au moins.

3. Au départ : 0,38 × 120 = 45,6, soit environ **46 élèves**. Cible : 0,25 × 120 = **30 élèves au plus**. Écart : 25 − 38 = **− 13 points**. Variation relative : (25 − 38) / 38 × 100 = **− 34,2 %**.

4. Pour une cible « au moins », on arrondit à l'entier supérieur (8,4 → 9), sinon on atteint moins que le pourcentage visé. Pour une cible « au plus », on arrondit à l'entier inférieur. On présente la cible en pourcentage et en effectif, ce qui la rend concrète pour l'équipe.

Corrigé – Exercice 7.40

1. On reformule chaque élément de l'arbre à problèmes de façon positive : le problème central devient l'objectif général (ou l'objectif spécifique principal), chaque cause retenue devient un objectif spécifique, les conséquences deviennent les effets attendus à long terme. Les causes non retenues apparaissent en grisé, avec la raison.

2. Contribuer à améliorer l'alimentation, notamment les apports en protéines, des personnes de 70 ans et

plus vivant seules à Montclar-sur-Aune.

3. C1 → améliorer l'accès aux produits frais (transmise en partie à la commune et à la communauté de communes : transport, commerce ambulant ; le CCAS peut organiser un covoiturage solidaire vers le marché du jeudi). C2 → redonner l'envie de cuisiner et de manger (retenue : ateliers et repas partagés dans la salle des fêtes). C3 → adapter les textures aux difficultés de mastication (retenue en partie : conseils de recettes ; orientation vers le dentiste et le médecin traitant). C4 → réduire l'isolement au moment des repas (retenue : repas partagés). C5 → rendre le portage accessible (transmise au conseil d'administration du CCAS et au département : tarification selon les revenus).

4. Exemples : « D'ici juin 2027, au moins 15 des 25 personnes concernées mangent de la viande, du poisson ou des œufs au moins une fois par jour (questionnaire avant-après). » Valeur cible : 15 / 25 = 60 %. « D'ici juin 2027, au moins 10 des 15 personnes qui se sentent souvent seules participent au moins deux fois par mois au repas partagé (feuilles de présence). » Valeur cible : 10 / 15 = 66,7 %.

Corrigé – Exercice 7.41

1. Partir du constat central du diagnostic ; identifier la tension ou le paradoxe ; préciser le public, le lieu et le levier ; formuler une question ouverte.

2. a) Question fermée (réponse oui ou non) et jugeante, qui ne dit rien du levier. Version : « Comment aider les jeunes du foyer, qui achètent des produits sucrés faute d'autre choix le soir, à disposer de collations qu'ils aiment et qu'ils préparent eux-mêmes ? » b) Trop vaste, sans public ni lieu, avec un mot dévalorisant (« malbouffe »). Version : « En quoi des ateliers de cuisine rapide peuvent-ils aider les étudiants d'une résidence universitaire, équipés d'une seule plaque, à préparer des repas variés pour moins de 3 € ? » c) Elle part de la solution (l'atelier) au lieu du problème. Version : « Comment permettre aux familles du quartier, qui souhaitent cuisiner davantage mais manquent d'idées et de temps, d'intégrer plus de légumes à leurs repas avec leur budget ? »

3. Exemple : « Comment permettre aux salariés du chantier d'insertion, qui produisent des légumes sans en consommer, de mieux se nourrir pendant leur journée de travail, malgré des horaires matinaux, un budget faible et l'absence de cuisine chez près de la moitié d'entre eux ? »

4. Problème central : « Les salariés ont une alimentation insuffisante pendant la journée de travail » (situation). Problématique : « Comment leur permettre de mieux se nourrir… ? » (question à laquelle répond le projet). Objectif général : « Contribuer à améliorer l'alimentation et la santé des salariés en insertion du chantier » (but). Les trois portent sur le même public et le même enjeu, et les causes du diagnostic (horaires, budget, équipement, organisation) se retrouvent dans la problématique.

Corrigé – Exercice 7.42

1. Objectif général : contribuer à améliorer l'alimentation et l'autonomie dans la vie quotidienne des résidents du foyer Les Glycines. OS1 : d'ici fin 2027, le nombre de résidents qui achètent chaque jour des produits sucrés au distributeur passe de 27 à 18 au plus (sur 46). OS2 : d'ici fin 2027, au moins 30 résidents sur 46 participent au moins une fois par mois à la préparation d'un repas du dimanche. OO1 (OS1) : d'ici mars 2027, remplacer la moitié des produits du distributeur par des fruits, des laitages et des collations peu sucrées, en accord avec le gestionnaire. OO2 (OS1) : animer 6 ateliers « collations maison » d'une heure entre janvier et juin 2027. OO3 (OS2) : organiser chaque dimanche, de février à décembre 2027, un atelier de préparation du repas avec un moniteur et 6 résidents. OO4 (OS2) : réaliser avec les résidents, avant avril 2027, un classeur de 20 recettes illustrées faisables avec deux plaques et un four.

2. Tableau (exemple) :

Objectif	Indicateur	Départ	Cible	Source de vérification	Échéance
OS1	Nombre de résidents qui achètent chaque jour au distributeur	27 / 46	18 au plus	Relevé du gestionnaire sur 2 semaines	Décembre 2027

Objectif	Indicateur	Départ	Cible	Source de vérification	Échéance
OS2	Nombre de résidents qui ont préparé au moins un repas du dimanche par mois	0	30 au moins	Planning des ateliers	Décembre 2027
OO1	Part des produits du distributeur remplacés	0 %	50 %	Contrat et relevé du distributeur	Mars 2027
OO2	Nombre d'ateliers réalisés ; participants	0	6 ateliers	Feuilles de présence	Juin 2027
OO3	Nombre de dimanches avec atelier	0	40 au moins (sur 47)	Cahier de liaison des moniteurs	Décembre 2027
OO4	Classeur de recettes	0	20 recettes	Classeur	Avril 2027

3. Hypothèses : le gestionnaire du distributeur accepte de modifier l'offre ; le planning des moniteurs permet un atelier le dimanche. Risques : lassitude des résidents (mesure : choix des recettes par les résidents, rotation des groupes) ; dépassement du budget alimentaire du dimanche (mesure : recettes chiffrées à moins de 3,50 € par personne, achats groupés).

4. De haut en bas, « comment ? » : on contribue à l'objectif général en réduisant les achats sucrés (OS1) et en développant la préparation des repas (OS2) ; on réduit les achats sucrés en changeant le distributeur (OO1) et en apprenant des collations maison (OO2). De bas en haut, « pourquoi ? » : on change le distributeur pour réduire les achats sucrés, afin d'améliorer l'alimentation. Chaque objectif opérationnel sert un objectif spécifique, et chaque objectif spécifique répond à une cause du diagnostic.

Partie 8 – Synthèse : diagnostic en situation réelle et cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Utiliser un diagnostic local de santé et rattacher un projet à un contrat local de santé.
- Adapter le diagnostic au milieu (école, entreprise, établissement) et à ses instances.
- Rédiger et relire la partie « analyse de situation et diagnostic » d'un dossier.
- Défendre son diagnostic à l'oral devant un jury.
- Traiter un cas complet du diagnostic aux objectifs, avec un calcul de coût et d'apports (Ciqual 2025).

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Contrat local de santé (article L. 1434-10 du Code de la santé publique) : signé entre l'ARS et une collectivité pour mettre en œuvre le projet régional de santé sur un territoire ; il s'appuie sur un diagnostic local de santé, souvent réalisé avec l'observatoire régional de la santé.
- Portail des interventions probantes ou prometteuses de Santé publique France : à consulter avant de choisir une action ; transférer une action, c'est garder ses fonctions clés et l'adapter au public.
- Milieu scolaire : infirmière, médecin, chef d'établissement, gestionnaire, élèves, CESCE. Entreprise : direction, représentants du personnel, service de prévention et de santé au travail, prestataire ; anonymat des salariés. Établissement médico-social : conseil de la vie sociale, équipe soignante, cuisine.
- Plan de la partie diagnostic d'un dossier : structure ; contexte ; méthode et limites ; résultats ; synthèse (problème central, arbre, priorités) ; objectifs ; outils en annexe.

Exercice 7.43 – Diagnostic local de santé et contrat local de santé (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage dans une maison de quartier de la ville de Vernois (fictive). Votre tutrice vous transmet le diagnostic local de santé réalisé pour le contrat local de santé de la ville et vous demande d'en tirer parti pour votre projet sur l'alimentation des familles.

Document 1 – Extraits du diagnostic local de santé (données fictives, 2025)

- Réalisé par l'observatoire régional de la santé : indicateurs statistiques, entretiens avec 32 professionnels, réunions publiques avec 140 habitants.
- Priorités retenues : axe 1 « alimentation et activité physique des enfants et des familles » ; axe 2 « accès aux soins » ; axe 3 « santé mentale ».
- Fiche-action 1.2 : « Développer les ateliers culinaires dans les quartiers prioritaires » ; pilote : service de santé de la ville ; financement possible par l'ARS.
- Surpoids et obésité des enfants de grande section : 14,2 % dans les quartiers prioritaires, 8,1 % dans le reste de la ville (bilans de santé scolaire, 2023-2024).

À vous de jouer – Questions

1. Définissez le contrat local de santé et indiquez son fondement juridique et ses signataires. (2 pts)

2. Expliquez trois intérêts du diagnostic local de santé pour votre projet. (3 pts)

3. Calculez l'écart en points et le rapport entre les quartiers prioritaires et le reste de la ville, et nommez le type de besoin. (2 pts)

4. Indiquez comment vous rattachez votre projet au CLS et ce que vous faites avant de choisir l'action. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.44 – Un diagnostic en milieu scolaire (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le principal d'un collège de 640 élèves (fictif) vous demande un diagnostic sur la consommation des légumes au restaurant scolaire. Vous avez organisé une pesée des restes pendant quatre jours, à raison de 520 repas par jour.

Document 1 – Pesée des restes (données fictives, novembre 2026)

- Restes totaux sur quatre jours : 94,6 kg, dont 41,2 kg de légumes.
- Les légumes les plus jetés : haricots verts, chou-fleur, épinards ; les moins jetés : carottes râpées, maïs.
- Temps de repas moyen observé : 18 minutes.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre total de repas, la masse de restes par convive en grammes et la part des légumes dans les restes. (3 pts)
2. Citez les acteurs du collège à associer au diagnostic et l'instance où le présenter. (3 pts)
3. Proposez deux autres méthodes de recueil à combiner avec la pesée. (2 pts)
4. Formulez deux hypothèses explicatives à vérifier et la façon de les vérifier. (2 pts)
5. Indiquez comment associer les élèves eux-mêmes au diagnostic. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.45 – Un diagnostic en entreprise (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une entreprise de fabrication de meubles (fictive) de 312 salariés, qui travaille en équipes alternantes (matin, après-midi, nuit), souhaite améliorer l'alimentation des salariés. Le service de prévention et de santé au travail vous confie le diagnostic.

Document 1 – Premiers éléments (données fictives)

- Questionnaire en ligne et papier : 187 réponses.
- Le directeur demande « les résultats par service, avec les noms des personnes qui ne mangent pas la nuit, pour leur en parler ».
- Le service logistique compte 7 répondants.
- Le restaurant d'entreprise ferme à 14 h ; l'équipe de nuit dispose de distributeurs.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de participation. (1 pt)
2. Citez les acteurs de l'entreprise à associer et leur rôle. (3 pts)
3. Répondez au directeur par écrit, en refusant poliment sa demande et en proposant une solution. (4 pts)
4. Expliquez le risque de présenter des résultats pour le service logistique et proposez une règle de présentation. (2 pts)
5. Proposez deux pistes de diagnostic propres au travail de nuit. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.46 – Relire la partie « diagnostic » d'un dossier (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une étudiante de votre promotion vous demande de relire la partie « diagnostic » de son dossier de projet, réalisé dans une crèche associative (fictive).

Document 1 – Extrait du dossier

« La crèche accueille des enfants. Les enfants mangent trop de sucre, comme partout en France. J'ai fait un questionnaire : 80 % des parents donnent des jus de fruits (8 parents ont répondu). Le problème est qu'il n'y a pas d'atelier pour les parents. J'ai décidé de faire des ateliers car c'est ce que je préfère. Objectif : sensibiliser les parents. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez six défauts de cet extrait au regard de la méthode du chapitre. (6 pts)
2. Proposez le plan de la partie « analyse de situation et diagnostic » en six rubriques, avec ce que l'étudiante doit y mettre. (4 pts)
3. Réécrivez la phrase sur le questionnaire de façon correcte. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.47 – Défendre son diagnostic devant le jury (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – oral · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous présentez à l'oral le diagnostic réalisé dans le chantier d'insertion « Les Jardins du Pont-Vieux » (exercices 7.30 et 7.41). Le jury vous pose cinq questions.

Document 1 – Questions du jury

a) « Vous n'avez interrogé que 24 personnes. Vos résultats ont-ils une valeur ? »

b) « Pourquoi n'avez-vous pas utilisé de questionnaire écrit ? »

c) « Les coups de fatigue ne viennent-ils pas plutôt du manque de sommeil ? »

d) « Pourquoi ne pas avoir retenu l'absence de cuisine équipée comme priorité ? »

e) « Qu'avez-vous fait vous-même pendant le stage ? »

À vous de jouer – Questions

1. Rédigez une réponse argumentée de trois à cinq lignes à chaque question du jury. (10 pts)
2. Indiquez quatre attitudes à adopter pendant l'échange avec le jury. (2 pts)
3. Citez deux documents à garder sous la main pendant l'oral. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.48 – Cas complet : les repas des auxiliaires de vie « sur la route » (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 h*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage dans le service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) « Aide et Présence du Val Doré » (structure fictive). Les 64 auxiliaires de vie se rendent chez des personnes âgées ou en situation de handicap, en voiture, de 7 h 30 à 20 h, souvent avec des horaires coupés. La directrice a remarqué de nombreux arrêts de travail et des plaintes de fatigue. Elle vous confie, avec le service de prévention et de santé au travail, un diagnostic sur l'alimentation des auxiliaires pendant leur journée de travail, puis la proposition d'un projet. Budget : 2 500 € sur un an (direction et mutuelle, financement fictif).

Document 1 – Questionnaire anonyme (données fictives, octobre 2026) : 52 répondants sur 64

Réponse	Nombre
Déjeune dans sa voiture au moins 3 fois par semaine	38
Saute le déjeuner au moins une fois par semaine	21
Dispose de moins de 20 minutes pour déjeuner	33
Grignote des produits sucrés en voiture	29
Mange un fruit ou un légume au déjeuner	17
Boit moins d'un litre d'eau pendant la journée de travail	30
Dépense plus de 6 € par déjeuner (boulangerie, sandwich)	15

Croisement : parmi les 31 auxiliaires en horaires coupés, 16 sautent le déjeuner au moins une fois par semaine ; parmi les 21 en horaires continus, 5 sont dans ce cas.

Document 2 – Paroles recueillies

« Entre deux bénéficiaires, j'ai dix minutes : je mange un paquet de biscuits au volant. » « Je n'ose pas boire, il n'y a pas de toilettes sur la route. » « La salle de pause est à l'agence, à 25 km de mes tournées. » « Je prépare ma gamelle le soir, mais elle chauffe dans la voiture l'été. »

Document 3 – Notes du groupe de travail (de 0 à 10) et test PEARL

Problème	A	B	C	PEARL
P1 – Repas sautés	4	7	6	1-1-1-1-1
P2 – Grignotage sucré en voiture	6	5	6	1-1-1-1-1
P3 – Peu de fruits et légumes au déjeuner	7	5	7	1-1-1-1-1
P4 – Hydratation insuffisante	6	4	8	1-1-1-1-1
P5 – Pause trop courte (organisation des plannings)	6	6	3	1-1-1-0-1

Document 4 – Le déjeuner « gamelle » proposé en atelier (grammages nets par portion, pertes, prix fictifs)

Denrée	Grammage net	Perte	Prix
Boulgour (cru)	70 g	sans perte	3,00 € le kg
Pois chiches appertisés, égouttés	80 g	sans perte	2,80 € le kg égoutté
Tomates	80 g	5 %	2,90 € le kg

Denrée	Grammage net	Perte	Prix
Concombre	60 g	10 %	1,80 € le kg
Feta	30 g	sans perte	13,50 € le kg
Huile d'olive vierge extra	8 g	sans perte	8,50 € le kg
Yaourt nature (pot de 125 g)	1 pot	sans perte	0,25 € le pot
Pomme	150 g	10 %	2,40 € le kg
Citron, menthe, sel, poivre	–	–	forfait 1,20 € pour 12 portions

Le déjeuner habituel acheté en boulangerie (« formule » sandwich, boisson, dessert) coûte 6,50 €.

Document 5 – Extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Vitamine C (mg)
Boulgour de blé, cru (9690)	347	11,7	65,8	0,41	1,42	10,5	0,043	35	0
Pois chiche, appertisé, égoutté (20532)	122	6,74	15	0,5	2,68	5,45	0,54	41,2	0,1
Tomate sans précision, crue (20385)	19,2	0,6	3,69	3,22	< 0,5	1,02	< 0,013	6,78	20,1
Concombre, chair et peau, cru (20019)	16,8	0,65	2,87	1,67	0,11	0,5	0,012	19,2	2,8
Feta, au lait de brebis 70 % minimum et lait de chèvre 30 % maximum (12066)	284	15,1	0,45	traces	24,3	0,2	2,27	220	–
Huile d'olive vierge extra (17270)	899	0,25	traces	0	99,9	0	< 0,013	< 0,2	0
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	3,83	4,26	4	1,68	traces	0,1	137	< 2
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037	5,34	4,6

On calcule avec les poids nets ; « traces », « < » et « – » sont comptés 0 ; le citron et la menthe ne sont pas comptés.

À vous de jouer – Questions

Partie A – Diagnostic (14 points)

1. Calculez le taux de participation et les pourcentages du document 1. (4 pts)

2. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion d'auxiliaires qui sautent le déjeuner et interprétez-le. (2 pts)

3. Calculez le risque relatif de sauter le déjeuner en horaires coupés par rapport aux horaires continus, avec son intervalle de confiance à 95 % (formule : $\exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d)})$). Interprétez. (4 pts)

4. Classez les besoins selon Bradshaw à l'aide des documents 1 et 2, puis construisez l'arbre à problèmes. (4 pts)

Partie B – Priorités et objectifs (12 points)

5. Calculez les scores de Hanlon, appliquez le test PEARL et dites ce que devient P5. (4 pts)

6. Formulez la problématique du projet. (2 pts)

7. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et trois objectifs opérationnels SMART. (6 pts)

Partie C – Le déjeuner « gamelle » (10 points)

8. Calculez le coût d'une portion (pour 12 portions) et l'économie annuelle pour une auxiliaire qui remplace la formule de boulangerie trois jours par semaine pendant 46 semaines. (3 pts)

9. Calculez l'apport d'une portion du déjeuner complet en énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium et vitamine C, ainsi que la répartition de l'énergie. Commentez. (4 pts)

10. Présentez les règles d'hygiène pour transporter et conserver ce déjeuner en voiture toute la matinée. (3 pts)

Partie D – Budget et éthique (4 points)

11. Proposez un budget qui respecte les 2 500 €. (2 pts)

12. Présentez deux précautions éthiques propres à un diagnostic réalisé pour un employeur. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 7.43

1. Le contrat local de santé est un contrat signé entre l'agence régionale de santé et une collectivité (commune ou intercommunalité) pour mettre en œuvre le projet régional de santé sur un territoire ; il est prévu par l'article L. 1434-10 du Code de la santé publique.
2. Il fournit des données locales récentes et sourcées ; il indique les priorités et les fiches-actions déjà validées par les élus, les professionnels et les habitants ; il identifie les partenaires et les financements possibles (ARS), ce qui facilite la reconnaissance et le financement du projet.
3. Écart : 14,2 − 8,1 = **6,1 points** ; rapport : 14,2 / 8,1 = **1,75**. C'est un besoin **comparatif** (écart entre deux populations), qui traduit une inégalité territoriale de santé.
4. On présente le projet comme une contribution à la fiche-action 1.2 de l'axe 1 et l'on prend contact avec le service de santé de la ville, pilote de la fiche, et la coordinatrice du CLS. Avant de choisir l'action, on consulte le portail des interventions probantes ou prometteuses de Santé publique France et l'on vérifie que l'action répond aux causes identifiées dans le diagnostic de la maison de quartier.

Corrigé – Exercice 7.44

1. Repas : 4 × 520 = **2 080 repas**. Restes par convive : 94,6 kg × 1 000 / 2 080 = **45,5 g**. Part des légumes : 41,2 / 94,6 × 100 = **43,6 %** des restes.
2. Le principal, le gestionnaire et le chef de cuisine, l'infirmière et le médecin scolaire, les enseignants intéressés (sciences, éducation physique), les assistants d'éducation présents au self, les élèves délégués et les parents d'élèves. On présente le diagnostic au comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement (CESCE), puis au conseil d'administration si des décisions sont nécessaires.
3. Un questionnaire court aux élèves (goûts, temps de repas, faim) ; l'observation du self (file d'attente, temps à table, présentation des légumes) ; l'analyse des menus sur un mois ; un groupe de parole avec des élèves.
4. Les légumes peu appréciés sont préparés d'une façon qui ne plaît pas (texture, assaisonnement) : on le vérifie par une dégustation comparative et par l'analyse des fiches techniques. Le temps de repas est trop court : on le vérifie en mesurant l'attente et le temps à table, et en comparant les restes selon l'heure de passage.
5. Associer des élèves volontaires à la pesée et à l'analyse (éco-délégués, club santé), organiser un sondage réalisé par les élèves, leur faire présenter les résultats au CESCE et leur demander des propositions.

Corrigé – Exercice 7.45

1. 187 / 312 × 100 = **59,9 %**.
2. La direction (décision, moyens) ; les représentants du personnel au comité social et économique (relais, confiance des salariés) ; le service de prévention et de santé au travail (médecin, infirmière : pilotage et confidentialité) ; le prestataire de restauration et le gestionnaire des distributeurs (offre) ; des salariés de chaque équipe (participation).
3. Exemple : « Monsieur le Directeur, je vous remercie de l'intérêt que vous portez au diagnostic. Le questionnaire est anonyme et les salariés ont répondu à cette condition : je ne peux donc ni identifier les personnes, ni transmettre de noms. Les informations sur la santé et l'alimentation des salariés relèvent de la vie privée et sont suivies par le service de prévention et de santé au travail. Je vous propose une restitution des résultats par équipe (matin, après-midi, nuit), avec des propositions concrètes sur l'offre de nuit. Je reste à votre disposition pour en discuter. »
4. Avec 7 répondants, une réponse peut être attribuée à une personne précise (réidentification), et le pourcentage n'a pas de sens statistique. Règle : ne présenter aucun résultat pour un groupe de moins de 10 répondants ; regrouper les petits services.

5. Analyser l'offre accessible la nuit (contenu des distributeurs, possibilité de réchauffer un plat) ; recueillir par entretien l'organisation des repas de l'équipe de nuit (heure, sommeil, repas avant et après le poste) ; comparer les réponses des trois équipes.

Corrigé – Exercice 7.46

1. « Des enfants » : la structure et le public ne sont pas décrits (nombre, âge, fonctionnement). « Comme partout en France » : affirmation nationale sans source ni date. « 80 % » sur 8 parents : pourcentage sur un très petit effectif ; il faut écrire « 8 parents sur 10 » ou « … sur … » et préciser le nombre de familles de la crèche. Méthode non décrite (dates, passation, questions). « Il n'y a pas d'atelier » : problème formulé comme l'absence d'une solution. Choix de l'action par préférence personnelle, sans critères de priorité. « Sensibiliser » : objectif non observable, ni mesurable. Aucun besoin ressenti ni exprimé des parents ; aucune ressource ; aucune limite.

2. 1. Présentation de la crèche : statut, nombre d'enfants et âges, repas fournis, équipe. 2. Contexte : données sourcées sur le territoire, repères officiels pour les jeunes enfants, politiques (programme des 1 000 premiers jours, PNNS). 3. Méthode : questionnaire (dates, nombre de familles, passation), entretiens avec l'équipe, observation des goûters, limites. 4. Résultats : besoins normatifs, ressentis, exprimés, comparatifs, avec effectifs. 5. Synthèse : problème central, arbre à problèmes, priorité justifiée par des critères. 6. Objectifs : général, spécifiques, opérationnels SMART ; questionnaire en annexe.

3. Exemple : « Sur les 22 familles de la crèche, 10 ont répondu au questionnaire distribué du … au … ; 8 d'entre elles déclarent donner un jus de fruits à leur enfant au moins une fois par jour. Ce résultat porte sur un petit nombre de familles volontaires et doit être interprété avec prudence. »

Corrigé – Exercice 7.47

1. a) « J'ai interrogé tous les salariés, 24 sur 24 : ce n'est pas un échantillon mais un recueil exhaustif ; il n'y a donc pas d'erreur d'échantillonnage. En revanche, les effectifs sont petits : je présente les résultats en effectifs (“15 sur 24”), sans les généraliser à d'autres chantiers. » b) « Une partie des salariés est peu à l'aise avec l'écrit ; des entretiens courts, individuels, m'ont permis d'expliquer les questions, d'obtenir 100 % de réponses et de recueillir des paroles qui expliquent les chiffres. » c) « C'est possible : la fatigue a plusieurs causes, dont le sommeil et les trajets très matinaux, que j'ai d'ailleurs relevés. Je ne prétends pas que le repas est la seule cause ; je montre seulement que 15 salariés sur 24 commencent un travail physique à jeun, ce qui est un besoin en soi. » d) « C'est une cause importante, mais le chantier ne peut pas équiper les logements des salariés : ce n'est pas faisable par le projet. Je l'ai transmise à la conseillère en insertion, qui accompagne les démarches de logement, et le projet s'en accommode avec des recettes sans cuisson ou au four à micro-ondes. » e) « J'ai construit la grille d'entretien, mené les 24 entretiens, calculé les résultats, animé la réunion de restitution avec les salariés et proposé les objectifs au comité de pilotage. »

2. Écouter la question jusqu'au bout et reformuler si nécessaire ; répondre avec des faits et des chiffres ; reconnaître une limite sans se dévaloriser ; rester calme et courtois, et dire « je ne sais pas, mais je vérifierais ainsi… » plutôt qu'inventer.

3. Le tableau des résultats avec les effectifs et les dates ; l'arbre à problèmes et la grille de priorisation ; le questionnaire ou la grille d'entretien ; le budget.

Corrigé – Exercice 7.48

Partie A – Diagnostic

1. Participation : 52 / 64 × 100 = **81,2 %**. Déjeune dans la voiture : 38 / 52 = **73,1 %**. Saute le déjeuner : 21 / 52 = **40,4 %**. Moins de 20 minutes pour déjeuner : 33 / 52 = **63,5 %**. Grignote des produits sucrés : 29 / 52 = **55,8 %**. Fruit ou légume au déjeuner : 17 / 52 = **32,7 %**. Moins d'un litre d'eau : 30 / 52 = **57,7 %**. Plus de 6 € par déjeuner : 15 / 52 = **28,8 %**.

2. 1,96 × √(0,404 × 0,596 / 52) = 1,96 × 0,0680 = **0,133**, soit **± 13,3 points** ; IC à 95 % : **[27,0 % ; 53,7 %]**. Même dans l'hypothèse la plus favorable, plus d'une auxiliaire sur quatre saute le déjeuner chaque semaine. L'intervalle suppose toutefois que les répondants ressemblent aux 12 non-répondants.

3. Horaires coupés : 16 / 31 = **51,6 %** ; horaires continus : 5 / 21 = **23,8 %**. RR = 0,516 / 0,238 = **2,17**. Erreur type : √(1/16 − 1/31 + 1/5 − 1/21) = √(0,0625 − 0,0323 + 0,2000 − 0,0476) = √0,1826 = **0,427**. ln RR = 0,773 ; 1,96 × 0,427 = 0,837. IC : exp(0,773 − 0,837) = exp(− 0,064) = **0,94** ; exp(0,773 + 0,837) = exp(1,610) = **5,01**. RR = 2,17 [0,94 ; 5,01]. Les auxiliaires en horaires coupés semblent deux fois plus souvent concernées, mais l'intervalle contient 1 : la différence n'est pas statistiquement significative, en raison des petits effectifs. C'est une piste à confirmer, cohérente avec les paroles recueillies.

4. Besoins : normatif (67,3 % des auxiliaires, soit 35 sur 52, ne mangent ni fruit ni légume au déjeuner ; 57,7 % boivent moins d'un litre d'eau) ; ressenti (« je mange un paquet de biscuits au volant », « je n'ose pas boire ») ; exprimé (plaintes de fatigue remontées à la direction) ; comparatif (horaires coupés contre horaires continus, 51,6 % contre 23,8 %). Arbre à problèmes. Problème central : les auxiliaires ont une alimentation insuffisante et déséquilibrée pendant leur journée de travail (40,4 % sautent le déjeuner chaque semaine ; 32,7 % seulement mangent un fruit ou un légume au déjeuner). Causes : temps de pause court (63,5 %) et horaires coupés ; repas pris dans la voiture (73,1 %) ; salle de pause éloignée des tournées ; pas de toilettes sur la route, ce qui freine l'hydratation ; chaleur dans la voiture pour la gamelle ; coût des achats en boulangerie (28,8 % dépensent plus de 6 €). Conséquences : fatigue, baisse de vigilance au volant (risque d'accident), grignotage sucré (55,8 %), arrêts de travail possibles, coût pour les auxiliaires.

Partie B – Priorités et objectifs

5. P1 : (4 + 14) × 6 / 3 = 108 / 3 = **36,0**. P2 : (6 + 10) × 6 / 3 = 96 / 3 = **32,0**. P3 : (7 + 10) × 7 / 3 = 119 / 3 = **39,7**. P4 : (6 + 8) × 8 / 3 = 112 / 3 = **37,3**. P5 : (6 + 12) × 3 / 3 = 54 / 3 = **18,0**, et un 0 au critère « Ressources » : le projet de prévention n'a pas la main sur les plannings. Classement des problèmes retenus : P3 (39,7), P4 (37,3), P1 (36,0), P2 (32,0). P5 n'est pas abandonné : il est transmis à la direction et aux représentants du personnel, avec les chiffres du diagnostic (plaidoyer pour des pauses repas protégées), car il conditionne en partie les autres problèmes.

6. Exemple : « Comment permettre aux auxiliaires de vie du SAAD, qui déjeunent le plus souvent dans leur voiture en moins de vingt minutes, de prendre un déjeuner complet, transportable et économique et de mieux s'hydrater pendant leurs tournées ? »

7. Objectif général : contribuer à améliorer l'alimentation et la santé au travail des auxiliaires de vie du SAAD. OS1 : d'ici octobre 2027, au moins 50 % des auxiliaires mangent un fruit ou un légume au déjeuner au moins trois jours par semaine (contre 32,7 % ; questionnaire de suivi). OS2 : d'ici octobre 2027, la part des auxiliaires qui boivent moins d'un litre d'eau pendant la journée de travail passe de 57,7 % à 35 % au plus. OO1 : animer 6 ateliers « gamelle de tournée » de 2 heures à l'agence pour 12 auxiliaires chacun, entre janvier et juin 2027. OO2 : remettre à chaque auxiliaire, avant mars 2027, un kit comprenant un sac isotherme, une boîte hermétique et une gourde. OO3 : réaliser avec les auxiliaires, avant avril 2027, un livret de 15 recettes de déjeuners transportables à moins de 2,50 € la portion. (Un OO4 possible : présenter le diagnostic à la direction et au CSE avant février 2027 pour discuter des pauses repas.)

Partie C – Le déjeuner « gamelle »

8. Coût pour 12 portions : boulgour 0,84 kg × 3,00 = 2,52 € ; pois chiches 0,96 kg × 2,80 = 2,69 € ; tomates 960 / 0,95 = 1 010,5 g bruts, × 2,90 = 2,93 € ; concombre 720 / 0,90 = 800 g bruts, × 1,80 = 1,44 € ; feta 0,36 kg × 13,50 = 4,86 € ; huile d'olive 0,096 kg × 8,50 = 0,82 € ; yaourts 12 × 0,25 = 3,00 € ; pommes 1 800 / 0,90 = 2 000 g bruts, × 2,40 = 4,80 € ; forfait 1,20 €. Total : **24,25 €**, soit **2,02 €** par portion. Économie annuelle : (6,50 − 2,02) × 3 × 46 = **618 €** environ (897 € pour la formule contre 279 € pour la gamelle).

9. Apports d'une portion :

Apport	Taboulé de boulgour aux pois chiches et feta	Yaourt et pomme	Déjeuner complet
Énergie	523,06 kcal	143,62 kcal	**666,7 kcal**
Protéines	19,00 g	5,16 g	24,16 g

Apport	Taboulé de boulgour aux pois chiches et feta	Yaourt et pomme	Déjeuner complet
Glucides	62,87 g	22,72 g	85,59 g
dont sucres	4,26 g	20,90 g	25,16 g
Lipides	18,49 g	2,48 g	20,96 g
Fibres	12,89 g	2,10 g	14,99 g
Sel	1,15 g	0,13 g	1,28 g
Calcium	140,40 mg	179,26 mg	319,66 mg
Vitamine C	17,84 mg	6,90 mg	24,74 mg

Exemples de calcul : boulgour 70 × 347 / 100 = 242,9 kcal ; feta 30 × 2,27 / 100 = 0,68 g de sel ; yaourt 125 × 137 / 100 = 171,25 mg de calcium. Répartition de l'énergie : protéines 24,16 × 4 / 666,7 = **14,5 %** ; lipides 20,96 × 9 / 666,7 = **28,3 %** ; glucides 85,59 × 4 / 666,7 = **51,4 %** (le reste vient des fibres). Commentaire : un déjeuner complet et rassasiant, riche en fibres (15 g, grâce au boulgour et aux pois chiches, une légumineuse), avec des protéines végétales et laitières, environ trois portions de fruits et légumes (tomates, concombre, pomme) et aucun sucre ajouté (les sucres viennent du fruit et du yaourt). Le sel (1,28 g) vient surtout de la feta et des pois chiches en conserve ; on peut rincer les pois chiches. Le calcium (319,66 mg) couvre environ un tiers des 950 mg conseillés par jour (Anses, 2021). Il se mange froid, sans réchauffer, ce qui convient aux pauses courtes.

10. Préparer la gamelle la veille et la garder au réfrigérateur ; le matin, la placer dans un sac isotherme avec un pain de glace, avec le yaourt, à l'abri du soleil (jamais sur la plage arrière ni dans le coffre l'été) ; la consommer dans la matinée suivante, avant 14 h ; jeter les restes ; laver la boîte chaque soir ; se laver les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique avant de manger ; emporter une gourde d'eau et prévoir des points d'arrêt identifiés (toilettes publiques, agence, commerces partenaires) pour faciliter l'hydratation.

Partie D – Budget et éthique

11. Exemple de budget :

Poste	Calcul	Montant
Denrées des ateliers	6 ateliers × 24,25 €	145,50 €
Kits (sac isotherme, boîte, gourde)	64 × 14 €	896,00 €
Vacations de diététicienne	6 ateliers × 3 h × 45 €	810,00 €
Livret de recettes	64 exemplaires × 3 €	192,00 €
Équipement de la salle de pause	forfait	150,00 €
Évaluation (questionnaire de suivi)	forfait	50,00 €
Imprévus (environ 10 %)		225,00 €
Total		**2 468,50 €**

Le budget est respecté, avec une marge de 31,50 €. Les prix sont fictifs.

12. Anonymat absolu : aucune réponse individuelle ni liste nominative n'est transmise à la direction ; pas de résultats pour des groupes de moins de 10 personnes. Libre participation : répondre au questionnaire et venir aux ateliers ne doit avoir aucune conséquence sur l'emploi ; les ateliers ont lieu sur le temps de travail. Non-stigmatisation : on ne parle ni de poids ni de « mauvaises habitudes » ; on montre que les causes sont surtout liées à l'organisation du travail, ce qui engage aussi l'employeur.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Situer les étapes du cycle de projet ; distinguer analyse de situation et diagnostic ; classer des informations dans les huit rubriques ; citer une donnée avec sa source, son année et son champ ; comparer un territoire à sa référence ; repérer les acteurs	7.1 à 7.6			
2	Choisir une méthode de recueil ; corriger et construire un questionnaire ; préparer un entretien semi-directif ; réaliser un relevé de prix ; repérer les biais et exploiter un prétest	7.7 à 7.12			
3	Distinguer points et pour cent ; calculer moyenne et médiane ; choisir un graphique ; lire un tableau croisé ; calculer un risque relatif et son intervalle de confiance ; rédiger des résultats sur de petits effectifs	7.13 à 7.18			
4	Choisir une méthode d'échantillonnage ; répartir un échantillon stratifié ; construire des quotas ; calculer une marge d'erreur et une taille d'échantillon corrigée	7.19 à 7.24			
5	Classer les besoins selon Bradshaw ; construire un arbre à problèmes ; mesurer l'environnement alimentaire ; croiser des sources contradictoires ; mesurer un gradient social ; rédiger un diagnostic	7.25 à 7.30			
6	Justifier des priorités par des critères ; calculer des scores de Hanlon ; appliquer le test PEARL ; dépouiller un groupe nominal ; choisir une méthode participative ; construire une matrice FFOM croisée	7.31 à 7.36			
7	Hiérarchiser des objectifs ; rédiger des objectifs SMART ; calculer des valeurs cibles ; construire un arbre à objectifs ; formuler une problématique ; construire un cadre logique	7.37 à 7.42			
8	Utiliser un diagnostic local de santé ; adapter le diagnostic au milieu ; relire un dossier ; défendre son diagnostic à l'oral ; traiter un cas complet avec coût et apports	7.43 à 7.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5

CHAPITRE

07

Démarche de projet (1) : diagnostic, priorités et objectifs

Démarche de projet (1) | Analyse de situation | Diagnostic | Priorités | Objectifs

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 7 224
Mode d'emploi du cahier d'annales 224
Ce que le jury attend sur ce chapitre 224
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 225
S1 – « À bord, on mange quand on peut » : le diagnostic de santé nutritionnelle des marins-pêcheurs d'un port artisanal 225
S2 – « Je dois tenir pour lui » : un atelier culinaire pour les parents hébergés près d'un hôpital pédiatrique 229
S3 – « Au camping toute l'année, mais personne ne le sait » : diagnostic participatif et atelier culinaire avec les habitants permanents d'un camping 233
Partie II – Les corrigés détaillés 238
Corrigé S1 – « À bord, on mange quand on peut » : le diagnostic de santé nutritionnelle des marins-pêcheurs d'un port artisanal 238
Corrigé S2 – « Je dois tenir pour lui » : un atelier culinaire pour les parents hébergés près d'un hôpital pédiatrique 244
Corrigé S3 – « Au camping toute l'année, mais personne ne le sait » : diagnostic participatif et atelier culinaire avec les habitants permanents d'un camping 252
Grille d'auto-évaluation 262

Cahier d'annales E5 – chapitre 7

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes et les données des enquêtes sont fictives : elles sont construites pour l'entraînement et ne doivent pas être citées comme des données réelles. Les données nationales et les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« À bord, on mange quand on peut » : le diagnostic de santé nutritionnelle des marins-pêcheurs d'un port artisanal	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Je dois tenir pour lui » : un atelier culinaire pour les parents hébergés près d'un hôpital pédiatrique	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Au camping toute l'année, mais personne ne le sait » : diagnostic participatif et atelier culinaire avec les habitants permanents d'un camping	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 7 porte sur la première partie de la démarche de projet : analyse de situation, recueil et analyse de données, diagnostic, priorités et objectifs. Le jury vérifie que le candidat sait **recueillir** des données pertinentes avec une méthode justifiée (questionnaire, entretien, observation, données existantes, méthodes participatives), **calculer et interpréter** des indicateurs avec leur précision (pourcentages, intervalle de confiance, risque relatif, redressement), **repérer les biais**, **poser un diagnostic** argumenté (problème central, causes, conséquences, besoins selon Bradshaw, forces et faiblesses), **choisir des priorités** avec des critères explicites (Hanlon, PEARL, faisabilité, équité) et **rédiger des objectifs** hiérarchisés et SMART, reliés aux causes retenues. Il valorise la prudence dans l'interprétation (un petit échantillon, un intervalle qui contient 1) et la participation du public au diagnostic ; il pénalise les objectifs flous (« sensibiliser », « améliorer ») et les chiffres sans interprétation.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; repérer la demande, le public, le territoire, les ressources et les contraintes ; surligner chaque donnée chiffrée et sa source (fictive ou réelle). Pendant : pour chaque calcul, écrire la formule, le calcul posé, le résultat arrondi et une phrase d'interprétation ; construire l'arbre à problèmes avant d'écrire les objectifs, et vérifier que chaque objectif spécifique répond à une cause ; donner pour chaque objectif un indicateur, une valeur cible et une échéance. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « À bord, on mange quand on peut » : le diagnostic de santé nutritionnelle des marins-pêcheurs d'un port artisanal

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E4 (dossier de projet) et E5.A (étude de cas en santé publique).

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année à l'association de prévention « Cap Santé Marins » du port de pêche de Kerlivio (structure, port et territoire fictifs). L'infirmière coordinatrice vous transmet une demande du comité local des pêches : « Nos marins prennent du poids, sont fatigués, et on a eu deux malaises à bord l'an dernier. On voudrait faire quelque chose sur l'alimentation, mais on ne sait pas par où commencer. » Une enquête par questionnaire a été réalisée sur les quais avant votre arrivée. Vous devez compléter l'analyse de situation, poser le diagnostic, choisir les priorités, rédiger les objectifs et présenter un projet réaliste dans votre dossier E5.

Document 1 – Le port, le public et les moyens

- 312 marins-pêcheurs actifs sont rattachés au port : 196 pratiquent la pêche côtière (sorties à la journée, départ entre 3 h et 5 h, retour entre 14 h et 18 h) et 116 la pêche au large (marées de 8 à 12 jours en mer, équipages de 5 à 7 personnes) ; 284 hommes et 28 femmes ; âge moyen 41 ans.
- À bord des bateaux du large, un marin assure la cuisine en plus de son travail de pont, sur un réchaud à deux feux, avec un réfrigérateur et un congélateur de petite taille. Sur les bateaux côtiers, chacun apporte son repas, sans moyen de le réchauffer sur la plupart des unités.
- Partenaires : comité local des pêches ; coopérative maritime (qui vend l'avitaillement des bateaux, c'est-à-dire les vivres et le matériel) ; Maison des gens de mer (salle de réunion, cuisine équipée de 6 postes) ; médecin des gens de mer (vacations) ; centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) de la ville voisine ; lycée maritime (formation des futurs marins).
- Ressources de l'association : une infirmière à 0,8 équivalent temps plein, une secrétaire, vous-même pendant 8 semaines. Budget du projet : 3 500 € sur douze mois (appel à projets de prévention de l'agence régionale de santé, financement fictif dans ce sujet), hors salaires.

Document 2 – Résultats de l'enquête par questionnaire de février 2027 (données fictives)

Questionnaire papier de 22 questions, proposé sur les quais au retour des bateaux par l'infirmière, pendant trois semaines, aux marins volontaires. Le poids et la taille sont **déclarés** par les marins. 148 questionnaires exploitables.

Indicateur	Pêche côtière (n = 92)	Pêche au large (n = 56)	Ensemble (n = 148)
IMC déclaré ≥ 25 (surpoids ou obésité)	51	41	92
dont IMC déclaré ≥ 30 (obésité)	17	18	35
Saute au moins un repas par jour en mer	34	22	56

Indicateur	Pêche côtière (n = 92)	Pêche au large (n = 56)	Ensemble (n = 148)
Mange des fruits ou des légumes au moins une fois par jour en mer	21	6	27
Boit au moins une boisson énergisante par jour en mer	27	12	39
Test AUDIT-C positif (consommation d'alcool à risque)	35	26	61

Autres résultats : 71 % des répondants disent « grignoter pour tenir » pendant le travail de nuit ; 64 % trouvent les repas à bord « trop gras » ; 58 % souhaitent « des idées de repas simples qui tiennent au corps » ; 23 % seulement se disent intéressés par « une réunion sur la nutrition ».

Document 3 – Paroles recueillies pendant le stage

« À bord, on mange quand on peut. Quand le poisson arrive, on trie, on ne s'arrête pas. » (Yann, 34 ans, pêche au large)

« Le cuisinier, c'est le plus jeune. Il fait des pâtes, des saucisses, des frites. Les légumes, ça ne tient pas, ça prend de la place et personne n'en veut. » (Patron d'un chalutier, 52 ans)

« Je pars à 4 heures avec un sandwich et deux canettes. Au retour je dors, puis je mange tout ce que je trouve. » (Morgane, 29 ans, pêche côtière)

« Mon mari revient avec 3 kilos de plus après chaque marée. Moi je fais attention à la maison, mais il n'est jamais là. » (Épouse d'un marin)

« La nutrition, c'est pour les gens de bureau. Nous, il nous faut de quoi tenir. » (Lucas, 23 ans, matelot)

« Si la coopérative proposait des paniers d'avitaillement prêts à l'emploi, avec des recettes, les patrons suivraient. » (Responsable de la coopérative maritime)

Document 4 – L'environnement alimentaire du port (observation réalisée pendant le stage)

- Sur le port : une friterie ouverte de 11 h à 22 h ; un distributeur automatique de la criée ouvert jour et nuit (sodas, boissons énergisantes, barres chocolatées, sandwichs industriels) ; aucun point d'eau potable en libre accès sur les quais.
- Le supermarché le plus proche est à 4 km ; le marché de producteurs a lieu le mercredi de 8 h à 12 h, quand les bateaux côtiers sont en mer.
- La coopérative maritime vend l'avitaillement des bateaux du large : listes types centrées sur les féculents, les viandes transformées, les conserves de plats cuisinés, les sodas et les biscuits ; aucun fruit frais en stock le week-end.
- La Maison des gens de mer est ouverte de 9 h à 17 h en semaine, au moment où les marins côtiers dorment ou sont en mer.

Document 5 – Priorisation proposée par le comité de pilotage (méthode de Hanlon)

Problème	A (ampleur, 0 à 10)	B (gravité, 0 à 10)	C (efficacité des interventions, 0 à 10)
P1 – Surpoids et obésité	7	6	5
P2 – Repas sautés et rythme alimentaire désorganisé en mer	6	5	7
P3 – Faible consommation de fruits et légumes à bord	9	4	7

Problème	A (ampleur, 0 à 10)	B (gravité, 0 à 10)	C (efficacité des interventions, 0 à 10)
P4 – Consommation d'alcool à risque	5	8	6
P5 – Consommation de boissons énergisantes	4	4	6

Score de Hanlon = (A + 2B) × C / 3. Le score est ensuite soumis au test PEARL (pertinence, économie, acceptabilité, ressources, légalité).

Document 6 – Repères utiles (données réelles)

- Étude Esteban 2014-2016 (Santé publique France, résultats publiés en 2017) : chez les adultes de 18 à 74 ans, mesures réalisées par des enquêteurs, 54 % des hommes et 44 % des femmes sont en surpoids ou obèses ; l'obésité concerne 17 % des adultes.
- Les études comparant poids déclaré et poids mesuré montrent en général une sous-estimation de l'IMC déclaré, donc de la prévalence du surpoids et de l'obésité.
- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des féculents complets au moins une fois par jour ; limiter les boissons sucrées, les produits gras, sucrés, salés et ultra-transformés ; l'eau est la seule boisson indispensable.
- Programme national nutrition santé 2026-2030 (PNNS 5, lancé le 8 avril 2026) : faire des milieux de vie des espaces favorables à la santé, pour que les choix sains deviennent les plus faciles.
- Intervalle de confiance à 95 % d'un pourcentage : $p \pm 1{,}96 \times \sqrt{p(1-p)/n}$. Taille d'échantillon : $n0 = 1{,}96^2 \times p(1-p)/e^2$, puis $n = n0 / (1 + (n0 - 1)/N)$ pour une population de taille N.
- Intervalle de confiance du risque relatif : $\exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d)})$, où a et c sont les nombres de cas chez les exposés et les non-exposés, a + b et c + d les effectifs.

Travail à faire

Partie A – Le projet d'intervention (dossier écrit de 10 pages au plus) – C3.1 (9 points)

1. Calculez le taux de participation à l'enquête (globalement et par type de pêche) et les prévalences du document 2 pour chaque groupe et pour l'ensemble. Comparez les résultats aux données nationales du document 6 en tenant compte de leurs différences de méthode. (2 pts)
2. Calculez la prévalence du surpoids et de l'obésité redressée selon le type de pêche de la population du port. Commentez. Identifiez quatre biais possibles de l'enquête et leur effet probable sur les résultats. (1,5 pt)
3. Construisez l'arbre à problèmes (problème central, au moins six causes à deux niveaux, conséquences) à partir des documents 2 à 4, puis l'analyse FFOM (forces, faiblesses, opportunités, menaces) du projet. Classez les besoins selon Bradshaw. (2 pts)
4. Calculez les scores de Hanlon du document 5, appliquez le test PEARL et justifiez les deux priorités retenues pour le projet. Expliquez ce que l'on fait du problème qui n'est pas retenu malgré un score élevé. (1,5 pt)
5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et quatre objectifs opérationnels SMART, chacun avec un indicateur, une valeur cible et une échéance ; vérifiez leur cohérence avec l'arbre à objectifs. Présentez les grandes actions et un budget prévisionnel qui respecte les 3 500 €. (2 pts)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée – C3.3 (3 points)

6. Calculez le risque relatif d'obésité et le risque relatif de surpoids (obésité comprise) des marins du large par rapport aux marins côtiers, avec leurs intervalles de confiance à 95 %. Interprétez en distinguant résultat significatif et résultat non significatif. (1,5 pt)
7. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la prévalence du surpoids dans l'ensemble des répondants, puis la taille d'échantillon nécessaire pour une précision de ± 5 points dans la population de 312 marins. Proposez une méthode d'échantillonnage et de recueil améliorée pour une nouvelle enquête dans un an. (1,5 pt)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

8. Organisez une veille sur la santé et l'alimentation des travailleurs de la mer et sur les horaires atypiques : sources fiables, outils, fréquence, modalités de partage avec l'équipe et les partenaires. (2 pts)

Partie D – Communication et posture professionnelle – C3.5 et C3.6 (3 points)

9. Proposez une méthode participative pour compléter le diagnostic avec les marins (organisation, horaires, lieu, déroulement) et une stratégie de communication adaptée à un public qui dit que « la nutrition, c'est pour les gens de bureau ». (1,5 pt)

10. Rédigez la trame minutée de votre exposé de 10 minutes et listez 15 questions probables du jury, avec les éléments de réponse attendus pour cinq d'entre elles. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Je dois tenir pour lui » : un atelier culinaire pour les parents hébergés près d'un hôpital pédiatrique

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des sujets U62 et E5.B (bon de commande, fiche technique, organisation dans le temps, hygiène), de la séquence du guide d'accompagnement 2025 consacrée à des femmes seules disposant d'une seule plaque (adaptation au matériel et au budget) et du BTS blanc CNED E5B (calcul nutritionnel).

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

La « Maison des familles de Bellerive » (association fictive) héberge, à deux pas de l'hôpital pédiatrique du CHU, les parents d'enfants hospitalisés pour plusieurs semaines (néonatologie, oncologie, chirurgie). Les parents disposent d'une chambre et d'une cuisine familiale partagée. L'équipe a réalisé un petit diagnostic auprès des familles (document 5) et vous demande de concevoir et d'animer un atelier culinaire qui permette aux parents de **préparer en peu de temps un repas complet, économique et rassasiant**, de **reprendre un rythme de repas** malgré les journées à l'hôpital, et de **partager un moment de répit** entre parents. La responsable insiste : « Ils pensent d'abord à leur enfant et s'oublient. On ne leur fait pas la leçon : on leur donne des solutions. »

Document 1 – Le public et les contraintes

- 8 parents de 27 à 52 ans, hébergés depuis 1 à 12 semaines. Plusieurs mangent au distributeur de l'hôpital ou sautent des repas.
- Madame A., 31 ans, allaite : son bébé, né prématuré, est en néonatologie ; elle tire son lait plusieurs fois par jour.
- Madame D., 39 ans, dont la fille est en oncologie depuis trois mois, a perdu 6 kg et dit « ne plus avoir faim ».
- Monsieur K., 44 ans, a un diabète de type 2 traité par comprimés.
- Madame S., 38 ans, est végétarienne (elle mange des œufs et des produits laitiers).
- Monsieur P., 27 ans, dit « ne jamais avoir cuisiné ».
- Madame T., 52 ans, grand-mère, est allergique aux fruits à coque.
- Monsieur B., 35 ans, ne mange pas de porc.
- Cuisine familiale partagée : 4 plaques à induction, 1 four, 1 four à micro-ondes, 2 réfrigérateurs avec une étagère par famille, 2 plans de travail ; pas de robot. Règlement de la maison : les plats préparés sont rangés dans une boîte fermée, étiquetée (nom, date), et consommés dans les 48 heures.
- Budget denrées : au plus 2,20 € par portion ; on prévoit 10 portions (8 parents, la bénévole qui co-anime et vous).
- Durée de l'atelier avec les parents : 1 h 30, de 14 h à 15 h 30, entre deux visites dans les services, dégustation comprise ; deux parents peuvent être appelés par le service pendant l'atelier. Le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 2 – Menu imposé

Plat : frittata (omelette épaisse cuite au four) aux pommes de terre, aux épinards et à l'emmental ; carottes râpées à la vinaigrette ; pain de campagne.

Dessert : crumble pommes-poires aux flocons d'avoine.

Le candidat réalise le plat et le dessert. Il présente une version « en 20 minutes » réalisable le soir avec une seule poêle, les adaptations pour Madame A., Madame D., Monsieur K. et Madame T., et l'organisation pour emporter une portion à l'hôpital le lendemain.

Document 3 – Grammages nets par portion, pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Pommes de terre	120 g	15 %	1,40 € le kg
Épinards hachés surgelés	60 g	sans perte	2,90 € le kg
Oignons	20 g	10 %	1,80 € le kg
Œufs (calibre moyen, 50 g net)	1,5 œuf (75 g)	sans perte	0,25 € l'œuf
Emmental râpé	15 g	sans perte	9,90 € le kg
Lait demi-écrémé	20 g	sans perte	1,05 € le litre (1 L = 1 kg)
Huile d'olive vierge extra	5 g	sans perte	8,50 € le kg
Carottes	60 g	15 %	1,50 € le kg
Huile de colza (vinaigrette)	4 g	sans perte	3,20 € le kg
Pain de campagne	40 g	sans perte	4,20 € le kg
Pommes	80 g	20 %	2,40 € le kg
Poires	60 g	20 %	2,90 € le kg
Flocons d'avoine	12 g	sans perte	2,20 € le kg
Farine de blé T55	10 g	sans perte	1,10 € le kg
Beurre doux	8 g	sans perte	9,80 € le kg
Sucre blanc	6 g	sans perte	1,20 € le kg
Cannelle, vinaigre, moutarde, muscade, sel, poivre	–	–	forfait 0,80 € pour l'atelier

Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte).

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	80	2,02	16,2	0,78	0,09	2,2	< 0,0011	14,3	0,78	19,7
Epinard, haché ou purée ou en branches, surgelé, cru (20083)	28	3,32	1	0,83	0,54	2,95	0,14	129	1,89	15,3
Oignon, cru (20034)	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098	25	0,00019	3,9
Oeuf cru (22000)	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31	76,8	1,75	0
Emmental ou emmenthal, râpé (12118)	368	27,6	0,58	traces	28,2	0,042	0,68	977	< 0,25	< 0,5
Lait demi-écrémé, pasteurisé (19042)	46,4	3,19	4,9	4,81	1,54	0	0,078	119	0,041	1,6

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Huile d'olive vierge extra (17270)	899	0,25	traces	0	99,9	0	< 0,013	< 0,2	< 0,05	0
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12	36,2	< 0,25	3,73
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0,023	0
Pain de campagne (7100)	253	7,52	50	2,5	1,3	4,3	1,18	23	1,5	< 0,5
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037	5,34	0,099	4,6
Poire, chair et peau, crue (13037)	56,6	0,36	12,3	9,75	0,27	2,9	0,0045	6,46	0,072	4,3
Flocons d'avoine (32140)	369	10,6	57,7	1,04	7,82	11,2	0,011	52	3,8	0
Farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains) (9436)	350	9,03	73,7	1,5	1	3,2	< 0,13	23	1	< 0,5
Beurre à 80% MG minimum, doux (16400)	753	0,64	0,71	0,71	83	0	0,035	19,8	< 0,5	0
Sucre blanc (31016)	399	0	99,7	99,7	0	0	0,0054	3,69	0,077	0
Cannelle, poudre (11025)	243	3,99	27,5	2,17	1,24	53,1	0,025	1000	8,32	3,8

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. On compte 0,3 g de cannelle par portion ; le sel ajouté, la moutarde et le vinaigre ne sont pas comptés. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 5 – Petit diagnostic réalisé par l'équipe auprès des parents hébergés (données fictives, mars 2027)

Questionnaire de 10 questions proposé à tous les parents présents pendant deux semaines ; 26 réponses sur 34 parents hébergés.

- 17 parents prennent au moins un repas par jour au distributeur ou à la cafétéria de l'hôpital ;
- 15 sautent régulièrement le petit déjeuner et 9 sautent régulièrement le dîner ;
- 19 disent « ne pas avoir le temps » de cuisiner et 8 « ne pas savoir cuisiner » ;
- 21 aimeraient des recettes « prêtes en moins de 20 minutes » ;
- 12 déclarent dépenser plus de 10 € par jour pour se nourrir et trouvent cela « trop cher » ;
- 14 disent qu'un moment entre parents leur ferait du bien.

Document 6 – Trois situations qui pourraient se présenter pendant l'atelier

Pendant l'épluchage, Madame D. se met à pleurer et dit qu'elle « n'arrive plus à rien ». Un père vous demande ce que doit manger son fils de 6 ans « pendant sa chimiothérapie, parce que l'hôpital ne lui dit rien ». La présidente de l'association souhaite des photos de l'atelier pour la page de l'association sur un réseau social et pour le dossier de demande de subvention.

Document 7 – Repères utiles (données réelles)

- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des féculents complets au moins une fois par jour ; des produits laitiers deux fois par jour ; limiter les produits sucrés.
- Pendant l'allaitement, les recommandations du Programme national nutrition santé conseillent une alimentation variée, sans régime restrictif, et de boire de l'eau selon la soif.
- Anses (références nutritionnelles pour la population, 2021) : calcium 950 mg par jour pour l'adulte de 25 ans et plus, 1 000 mg de 18 à 24 ans ; vitamine C 110 mg par jour pour l'adulte.
- L'OMS (2015) recommande de limiter les sucres libres (sucres ajoutés et sucres des jus de fruits et du miel) à moins de 10 % de l'apport énergétique.
- Règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) : information sur 14 allergènes, dont le gluten, les œufs, le lait et les fruits à coque, y compris pour les denrées non préemballées.
- Bonnes pratiques d'hygiène : les préparations à base d'œufs sont cuites à cœur ; un plat préparé à l'avance est refroidi rapidement puis conservé au réfrigérateur à 4 °C au plus.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (11 points)

1. Exploitez le document 5 (taux de réponse et pourcentages) et dégagez trois besoins prioritaires du public. Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier, mesurables à la fin de la séance. (2 pts)

2. Établissez le bon de commande pour 10 portions (quantités nettes, quantités brutes, unités de commande, coût) ; calculez le coût par portion et vérifiez le respect du budget. (2 pts)

3. Rédigez la fiche technique du plat et du dessert (ingrédients, matériel, étapes, points critiques). Présentez la version « en 20 minutes avec une seule poêle », les adaptations pour Madame A., Madame D., Monsieur K. et Madame T., et l'organisation pour emporter une portion à l'hôpital. (3 pts)

4. Calculez l'apport d'une portion du repas en énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer et vitamine C, et la répartition de l'énergie ; calculez la part de l'énergie apportée par les sucres ajoutés ; commentez au regard des repères, en particulier pour Madame A. et Madame D. (2 pts)

5. Présentez le cadre de l'atelier : accueil, confidentialité entre parents, liberté de participer et de partir à tout moment, limites de votre rôle, droit à l'image. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et participants), en prévoyant le départ possible de deux parents en cours d'atelier. (2 pts)

7. Présentez les méthodes d'animation et les outils (démonstration, binômes, fiche recette imagée, échange sur les repas à l'hôpital, « faire dire »), ainsi qu'une grille de dégustation. (1,5 pt)

8. Présentez les règles d'hygiène (5 M, œufs, refroidissement, étiquetage et durée de conservation), la sécurité (four, couteaux), la gestion des allergènes et trois éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

9. Réalisez le plat et le dessert ; dressez une assiette et une part de crumble, et conditionnez une portion à emporter. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier (satisfaction, sentiment d'être capable de refaire la recette, intention de refaire, répit ressenti) et analysez les trois situations du document 6, avec la réponse que vous donnez à chaque personne. (1 pt)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Au camping toute l'année, mais personne ne le sait » : diagnostic participatif et atelier culinaire avec les habitants permanents d'un camping

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet de synthèse – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2)

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Temps 1 : préparation conseillée 3 h, puis 30 min d'oral blanc · Temps 2 : 3 h · Barème : 20 points par temps. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la séquence du guide d'accompagnement 2025 (ville de Trait : femmes bénéficiaires de colis disposant d'une seule plaque de cuisson) et de la structure des sujets U62 et E5.B.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique au centre communal d'action sociale (CCAS) de Lorvenec-sur-Estuaire (commune et structure fictives, 4 800 habitants). La travailleuse sociale du CCAS a repéré que de nombreux ménages vivent toute l'année dans les mobil-homes et caravanes du camping « Les Pins de l'Estuaire » (fictif), à 9 km du centre-bourg. Ils sont peu visibles : « Ils ne viennent jamais au CCAS, ils ont peur qu'on les remarque. » La directrice vous demande de **réaliser le diagnostic** de la situation alimentaire de ces habitants avec eux, de **proposer un projet** et d'**animer un premier atelier culinaire** dans la salle commune du camping.

Document 1 – Le camping, les habitants et les moyens

- 64 emplacements sont occupés à l'année par 52 ménages (97 personnes, dont 21 enfants). Profils : personnes seules de plus de 60 ans avec une petite retraite, personnes seules ou couples bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), quelques familles avec enfants, des travailleurs saisonniers devenus permanents.
- Les ménages louent leur emplacement au gérant. Certains craignent que leur présence à l'année ne soit « pas autorisée » et évitent les services publics.
- Équipement habituel : réchaud à gaz à deux feux, petit réfrigérateur ; peu de fours ; eau froide à l'intérieur, sanitaires collectifs ; salle commune de 40 m² avec deux réchauds à gaz de deux feux, un évier, une grande table, sans four ni réfrigérateur.
- Environnement : une épicerie à l'entrée du camping, ouverte seulement de juin à septembre ; le supermarché et le marché sont au centre-bourg, à 9 km ; trois bus aller-retour par jour en semaine (1,20 € le trajet) ; une distribution de colis alimentaires une fois par mois à la mairie, le mardi matin.
- Ressources : la travailleuse sociale du CCAS (une demi-journée par semaine au camping pendant le projet), une habitante du camping volontaire comme « habitante relais », vous-même pendant 8 semaines, la banque alimentaire départementale, le jardin partagé de la commune. Budget du projet : 2 000 € sur un an (CCAS et conférence des financeurs, financement fictif dans ce sujet), hors salaires.

Document 2 – Diagnostic par entretiens au domicile (données fictives, février et mars 2027)

Entretiens de 20 minutes menés au domicile par la travailleuse sociale et l'habitante relais, auprès de tous les ménages qui acceptaient de les recevoir. 41 ménages rencontrés sur 52.

Réponse (un adulte par ménage)	Nombre de ménages
Ne dispose que d'un réchaud à deux feux, sans four	29
Dispose d'un réfrigérateur de moins de 100 litres	33
N'a pas de voiture en état de marche	17
Mange des fruits ou des légumes moins de cinq fois par semaine	22
A sauté au moins un repas le mois dernier par manque d'argent	14

Réponse (un adulte par ménage)	Nombre de ménages
Fréquente la distribution de colis de la mairie	9
Souhaite participer à des ateliers « cuisine simple au réchaud »	26

Croisement selon l'âge de l'adulte interrogé : parmi les 25 adultes de moins de 60 ans, 11 ont sauté au moins un repas le mois dernier par manque d'argent ; parmi les 16 adultes de 60 ans et plus, 3 sont dans ce cas.

Document 3 – Paroles recueillies

« Au camping, personne ne vient nous voir. On est entre nous, c'est notre force et notre problème. » (Jacqueline, 68 ans)

« Les colis, c'est le mardi matin, et le bus de 9 h passe à 8 h 40. Si je le rate, j'ai tout perdu. » (Nordine, 51 ans)

« Avec deux feux et pas de four, je fais des pâtes, des conserves, des œufs. Les légumes frais, je n'ai pas la place de les garder. » (Sandra, 37 ans, deux enfants)

« L'été, l'épicerie est là. L'hiver, si on n'a pas de voiture, on vit sur les réserves. » (Gérard, 72 ans)

« Ce qui me ferait plaisir, c'est de cuisiner avec d'autres, comme avant. » (Martine, 63 ans)

« Pas de photo, pas de nom. On ne veut pas d'histoires avec le gérant. » (Un habitant)

Document 4 – Repères utiles (données réelles)

- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour, frais, surgelés ou en conserve ; des légumes secs au moins deux fois par semaine ; des féculents complets au moins une fois par jour.
- Programme national nutrition santé 2026-2030 (PNNS 5, lancé le 8 avril 2026) : réduire les inégalités sociales de santé dans le champ de la nutrition et améliorer l'accès à une alimentation favorable à la santé pour les personnes en situation de précarité.
- Article L. 266-1 du Code de l'action sociale et des familles (loi EGalim, 2018) : la lutte contre la précarité alimentaire vise à favoriser l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, dans des conditions qui respectent la dignité des personnes et développent leur capacité à agir.
- Le riz cuit peut contenir des spores de *Bacillus cereus* qui résistent à la cuisson ; un riz cuit laissé à température ambiante permet leur germination et la production de toxines : il doit être consommé rapidement ou refroidi vite et conservé au froid.
- Intervalle de confiance du risque relatif : $\exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{(1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d))})$.

Temps 1 – Travail à faire (20 points)

Partie A – Le projet d'intervention – C3.1 (9 points)

1. Calculez le taux de participation au diagnostic et les pourcentages du document 2. Expliquez pourquoi un recueil exhaustif par entretien au domicile a été préféré à un questionnaire déposé dans les boîtes aux lettres, et ce que représentent les 11 ménages non rencontrés. (2 pts)

2. Calculez, à partir du croisement selon l'âge, la part des adultes qui ont sauté un repas dans chaque groupe et le risque relatif avec son intervalle de confiance. Interprétez avec prudence. (1,5 pt)

3. Analysez l'environnement alimentaire des habitants (accès physique, accès économique, offre, équipement) et construisez l'arbre à problèmes. Classez les besoins selon Bradshaw. (2 pts)

4. Présentez l'analyse FFOM du projet, choisissez deux priorités avec des critères explicites (ampleur, gravité, faisabilité, demande des habitants, équité) et formulez la problématique du projet. (1,5 pt)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et quatre objectifs opérationnels SMART, puis présentez les actions, leur calendrier sur un an et un budget qui respecte les 2 000 €. (2 pts)

Partie B – Recherche appliquée et veille – C3.3 et C3.4 (4 points)

6. Proposez une méthode participative pour approfondir le diagnostic avec les habitants (par exemple un photolangage ou une technique du groupe nominal) : déroulement, matériel, précautions. (2 pts)

7. Organisez une veille sur la précarité alimentaire et l'habitat précaire : sources fiables, outils, fréquence, diffusion à l'équipe. (2 pts)

Partie C – Communication et éthique – C3.5 et C3.6 (4 points)

8. Présentez les précautions éthiques du projet : discrétion, confidentialité des entretiens, données, absence de photos, relation avec le gérant, non-stigmatisation. (2 pts)

9. Rédigez l'invitation au premier atelier (écrite claire et orale) et la trame minutée de votre exposé de 10 minutes. (2 pts)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Temps 2 – L'atelier « cuisiner au réchaud » (20 points)

Document 5 – Le public et les contraintes de l'atelier

- 10 habitants inscrits, de 24 à 74 ans, dont Sandra et son fils de 9 ans (participation avec sa mère).
- Monsieur H., 67 ans, a une hypertension artérielle : son médecin lui demande de limiter le sel.
- Madame V., 45 ans, a une maladie cœliaque (régime strict sans gluten).
- Monsieur N., 51 ans, ne mange pas de porc.
- Madame J., 74 ans, a des difficultés pour mâcher (prothèse dentaire mal adaptée).
- Salle commune : deux réchauds à gaz de deux feux, une grande table, un évier, de l'eau froide ; pas de four, pas de réfrigérateur ; vous apportez deux glacières avec des pains de glace.
- Budget denrées : au plus 1,80 € par portion ; on prévoit 12 portions (10 habitants, la travailleuse sociale et vous).
- Durée de l'atelier avec les habitants : 2 h, de 10 h à 12 h, dégustation comprise. Le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 6 – Menu imposé, grammages nets par portion et prix (données construites pour le sujet)

Plat : riz sauté aux petits pois, aux carottes, à l'œuf et aux dés de jambon. Dessert : pommes poêlées à la cannelle et fromage blanc.

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Riz blanc long	70 g (cru)	sans perte	1,90 € le kg
Petits pois surgelés	50 g	sans perte	2,60 € le kg
Carottes	60 g	15 %	1,50 € le kg
Oignons	20 g	10 %	1,80 € le kg
Œufs (calibre moyen, 50 g net)	1 œuf	sans perte	0,25 € l'œuf
Dés de jambon cuit supérieur, découenné, dégraissé	30 g	sans perte	10,50 € le kg
Huile de colza	6 g	sans perte	3,20 € le kg
Sauce soja	5 g	sans perte	6,00 € le kg
Pommes	120 g	20 %	2,40 € le kg
Beurre doux	4 g	sans perte	9,80 € le kg
Sucre blanc	4 g	sans perte	1,20 € le kg

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Fromage blanc nature 2-3 % de matières grasses	80 g	sans perte	2,90 € le kg
Cannelle, poivre	–	–	forfait 0,30 € pour l'atelier

Document 7 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Riz blanc, cru (9100)	350	7,02	77,5	0,12	0,79	1,53	0,0079	13,3	1,94	0
Petits pois, surgelés, crus (20084)	77,9	5,86	9,5	3,75	0,4	6,45	0,18	22	1,53	18
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12	36,2	< 0,25	3,73
Oignon, cru (20034)	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098	25	0,00019	3,9
Oeuf cru (22000)	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31	76,8	1,75	0
Jambon cuit, supérieur, découenné dégraissé (28906)	115	20,3	0,14	0,14	3,66	0,32	1,82	< 20	0,8	–
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0,023	0
Sauce soja, préemballée (11104)	39,9	7,25	1,72	traces	< 0,5	0,9	13,1	28,9	2,1	2,64
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037	5,34	0,099	4,6
Beurre à 80% MG minimum, doux (16400)	753	0,64	0,71	0,71	83	0	0,035	19,8	< 0,5	0
Sucre blanc (31016)	399	0	99,7	99,7	0	0	0,0054	3,69	0,077	0
Cannelle, poudre (11025)	243	3,99	27,5	2,17	1,24	53,1	0,025	1000	8,32	3,8
Fromage blanc, nature, 2-3% MG (19646)	75,7	7,28	3,86	3,86	3,23	0,019	0,088	131	< 0,25	< 2

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < », « traces » ou « – » est comptée 0. On compte 0,3 g de cannelle par portion ; le sel ajouté n'est pas compté.

Partie 1 – Conception (11 points)

10. Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier, reliés au diagnostic du temps 1. (1,5 pt)

11. Établissez le bon de commande pour 12 portions et calculez le coût par portion. (2 pts)

12. Rédigez la fiche technique adaptée au matériel de la salle commune (deux réchauds, pas de four, pas de réfrigérateur) et présentez les adaptations pour Monsieur H., Madame V., Monsieur N., Madame J. et l'enfant de 9 ans. (3 pts)

13. Calculez l'apport d'une portion du repas en énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer et vitamine C, et la répartition de l'énergie. Calculez la part du sel apportée par la sauce soja et commentez pour Monsieur H. (2,5 pts)

14. Comparez le coût d'une portion à celui d'un plat cuisiné en conserve de 300 g à 2,40 € et présentez trois autres recettes « au réchaud » réalisables avec les produits secs et surgelés d'un placard et d'un petit congélateur. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

15. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et participants) avec deux réchauds pour douze personnes. (2 pts)

16. Présentez les méthodes d'animation qui valorisent les savoir-faire des habitants, le rôle de l'habitante relais et une grille de dégustation adaptée. (1,5 pt)

17. Présentez les règles d'hygiène sans réfrigérateur (glacières, températures, riz cuit et *Bacillus cereus*, œufs, restes), la sécurité au gaz et trois éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

18. Réalisez le plat et le dessert ; dressez une assiette et une coupe de dessert. (3 pts)

19. Proposez l'évaluation de l'atelier, sans écrit obligatoire, et la suite du projet. (1 pt)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « À bord, on mange quand on peut » : le diagnostic de santé nutritionnelle des marins-pêcheurs d'un port artisanal

que le jury attend

Le jury évalue la rigueur du diagnostic : calculs justes et interprétés, comparaison prudente avec les données nationales, repérage des biais (poids déclaré, recrutement sur les quais, volontariat), arbre à problèmes cohérent avec les documents, priorisation argumentée et objectifs SMART reliés aux causes retenues. Il valorise la prise en compte des conditions de travail (horaires, marées, place à bord) et des leviers d'environnement (avitaillement, distributeur, point d'eau) plutôt qu'un projet centré sur l'information. Il pénalise un projet de « réunions nutrition » que le public a refusé (23 % d'intérêt), des objectifs comme « sensibiliser les marins », et la confusion entre un résultat non significatif et une absence de différence.

Partie A – Le projet d'intervention

Question 1 – Participation, prévalences et comparaison (2 pts)

Calcul posé – Indicateurs de l'enquête de février 2027

- Taux de participation : 148 / 312 × 100 = **47,4 %** ; pêche côtière : 92 / 196 × 100 = **46,9 %** ; pêche au large : 56 / 116 × 100 = **48,3 %**.
- Surpoids ou obésité (IMC déclaré ≥ 25) : côtière 51 / 92 = **55,4 %** ; large 41 / 56 = **73,2 %** ; ensemble 92 / 148 = **62,2 %**.
- Obésité (IMC déclaré ≥ 30) : côtière 17 / 92 = **18,5 %** ; large 18 / 56 = **32,1 %** ; ensemble 35 / 148 = **23,6 %**.
- Au moins un repas sauté par jour en mer : côtière 34 / 92 = **37,0 %** ; large 22 / 56 = **39,3 %** ; ensemble 56 / 148 = **37,8 %**.
- Fruits ou légumes au moins une fois par jour en mer : côtière 21 / 92 = **22,8 %** ; large 6 / 56 = **10,7 %** ; ensemble 27 / 148 = **18,2 %**.
- Boisson énergisante quotidienne : côtière 27 / 92 = **29,3 %** ; large 12 / 56 = **21,4 %** ; ensemble 39 / 148 = **26,4 %**.
- AUDIT-C positif : côtière 35 / 92 = **38,0 %** ; large 26 / 56 = **46,4 %** ; ensemble 61 / 148 = **41,2 %**.

Comparaison : la prévalence du surpoids ou de l'obésité des répondants (62,2 %) et celle de l'obésité (23,6 %) sont supérieures aux données de l'étude Esteban (54 % des hommes en surpoids ou obèses ; 17 % d'obésité chez les adultes). La comparaison doit rester prudente : l'enquête du port repose sur un poids **déclaré**, qui sous-estime en général l'IMC, alors qu'Esteban utilise des **mesures** ; les populations diffèrent (91 % d'hommes au port, âge moyen 41 ans contre 18 à 74 ans) ; l'échantillon du port est petit et volontaire. Comme la sous-déclaration du poids tend à diminuer la prévalence, l'écart réel avec les données nationales est probablement au moins aussi important que l'écart observé. Le diagnostic retient donc un **excès de surpoids**, plus marqué chez les marins du large, des repas sautés pour plus d'un marin sur trois, une très faible consommation de fruits et légumes à bord, surtout au large (un marin sur dix), et des consommations à risque (boissons énergisantes, alcool).

Question 2 – Redressement et biais (1,5 pt)

Calcul posé – Prévalence redressée selon le type de pêche

Poids de chaque groupe dans la population du port : côtière 196 / 312 = 0,628 ; large 116 / 312 = 0,372.

Surpoids ou obésité redressé : 0,628 × 55,43 + 0,372 × 73,21 = 34,82 + 27,23 = **62,0 %** (62,2 % sans redressement).

Obésité redressée : 0,628 × 18,48 + 0,372 × 32,14 = 11,61 + 11,96 = **23,6 %**.

Le redressement modifie à peine le résultat, car l'échantillon respecte presque la répartition entre pêche côtière et pêche au large (62,2 % de côtiers dans l'échantillon contre 62,8 % dans la population). Le redressement ne corrige que ce déséquilibre-là : il ne corrige pas les autres biais.

Biais	Explication	Effet probable
Biais de déclaration du poids et de la taille	Les personnes sous-estiment leur poids et surestiment leur taille	Sous-estimation du surpoids et de l'obésité
Biais de désirabilité sociale	Réponses sur l'alcool, les repas sautés ou les boissons énergisantes données en face de l'infirmière	Sous-estimation des consommations à risque
Biais de sélection (volontariat)	Les marins les plus concernés, ou au contraire les plus éloignés de la santé, peuvent avoir répondu plus ou moins	Sens incertain ; résultats non généralisables avec certitude
Biais de recrutement (lieu et moment)	Questionnaire proposé sur les quais au retour, pendant trois semaines de février : les marins en marée longue ou épuisés au retour répondent moins	Sous-représentation possible des marins du large les plus exposés
Biais de mémoire	Questions sur le dernier mois ou les habitudes en mer	Imprécision des fréquences

Question 3 – Arbre à problèmes, FFOM et besoins (2 pts)

Problème central : **une alimentation irrégulière et peu diversifiée en mer, associée à un excès de surpoids chez les marins-pêcheurs du port de Kerlivio**.

Niveau	Contenu
Conséquences	Surpoids et obésité (62,2 % ; 73,2 % au large) ; fatigue, baisse de vigilance et risque d'accident ou de malaise à bord ; risque cardiovasculaire et de diabète de type 2 à long terme ; consommation de boissons énergisantes et de grignotage « pour tenir »
Causes immédiates	Repas sautés (37,8 %) ; très peu de fruits et légumes en mer (18,2 %) ; repas à bord riches en produits gras et transformés (64 % les trouvent « trop gras ») ; grignotage nocturne (71 %) ; boissons sucrées et énergisantes
Causes liées aux conditions de travail	Horaires décalés et travail de nuit ; tri du poisson prioritaire sur les pauses ; cuisinier de bord jeune et non formé ; réchaud à deux feux et faible place de stockage ; pas de moyen de réchauffer sur les bateaux côtiers
Causes liées à l'environnement alimentaire	Avitaillement de la coopérative centré sur les produits transformés, sans fruits le week-end ; distributeur de la criée ; friterie ; marché et Maison des gens de mer aux mauvais horaires ; aucun point d'eau sur les quais
Causes liées aux représentations	« La nutrition, c'est pour les gens de bureau » ; besoin de repas « qui tiennent au corps » ; légumes perçus comme encombrants et peu appréciés

FFOM du projet :

Forces (internes)	Faiblesses (internes)
Infirmière connue des marins ; données d'enquête récentes ; Maison des gens de mer équipée d'une cuisine ; demande portée par le comité local des pêches	Temps limité (0,8 ETP et stage de 8 semaines) ; budget de 3 500 € ; horaires du public difficiles à concilier ; faible intérêt pour les réunions (23 %)

Forces (internes)	Faiblesses (internes)
Opportunités (externes)	**Menaces (externes)**
Coopérative prête à proposer des paniers d'avitaillement ; lycée maritime (formation des futurs cuisiniers de bord) ; CSAPA pour l'alcool ; PNNS 5 (2026-2030) qui encourage l'action sur les milieux de vie	Contraintes économiques de la pêche (rentabilité des marées) ; culture professionnelle peu ouverte à la prévention ; turn-over des équipages ; fin éventuelle du financement après un an

Besoins selon Bradshaw : **normatif** (surpoids et obésité supérieurs aux données nationales, fruits et légumes très en dessous du repère « au moins cinq par jour », consommation d'alcool à risque) ; **ressenti** (fatigue, repas « trop gras » pour 64 %, épouse inquiète de la prise de poids) ; **exprimé** (demande du comité local des pêches ; 58 % souhaitent des idées de repas simples) ; **comparatif** (écart avec la population générale, et entre marins du large et marins côtiers).

Question 4 – Priorités (1,5 pt)

Calcul posé – Scores de Hanlon = (A + 2B) × C / 3

- P1 Surpoids : (7 + 12) × 5 / 3 = 95 / 3 = **31,7**.
- P2 Repas sautés : (6 + 10) × 7 / 3 = 112 / 3 = **37,3**.
- P3 Fruits et légumes : (9 + 8) × 7 / 3 = 119 / 3 = **39,7**.
- P4 Alcool : (5 + 16) × 6 / 3 = 126 / 3 = **42,0**.
- P5 Boissons énergisantes : (4 + 8) × 6 / 3 = 72 / 3 = **24,0**.

Classement : P4 (42,0) > P3 (39,7) > P2 (37,3) > P1 (31,7) > P5 (24,0).

Test PEARL : P4 a le score le plus élevé, mais la prise en charge de la consommation d'alcool à risque relève des compétences du CSAPA et du médecin des gens de mer (critère « ressources » et « pertinence » pour une action nutritionnelle) : il n'est pas abandonné, il est **confié** au partenaire compétent, avec une action conjointe (intervention du CSAPA lors d'un atelier, orientation des marins, information sur les liens entre alcool, sommeil et vigilance). Le projet retient **P3** (fruits et légumes à bord) et **P2** (repas sautés), qui obtiennent les meilleurs scores parmi les problèmes relevant de l'association, sont acceptables pour les marins (58 % demandent des idées de repas) et peuvent être traités par des leviers concrets (avitaillement, formation du cuisinier, gamelle). Le surpoids (P1) n'est pas traité directement par un discours sur le poids, souvent mal reçu : il est visé à long terme dans l'objectif général, à travers l'amélioration du rythme et de la qualité des repas. Les boissons énergisantes (P5) sont intégrées à P2 (alternatives pour tenir la nuit : collation, eau, café sans excès).

Question 5 – Objectifs, actions et budget (2 pts)

Niveau	Objectif	Indicateur et cible
Objectif général	Contribuer à améliorer la santé nutritionnelle des marins-pêcheurs du port de Kerlivio en favorisant des repas réguliers et diversifiés en mer	(non mesuré par le seul projet ; suivi à long terme de la prévalence du surpoids par le médecin des gens de mer)
OS1	D'ici juin 2028, la part des marins du large qui mangent des fruits ou des légumes au moins une fois par jour en mer passe de 10,7 % à au moins 30 %	Questionnaire de suivi, même méthode qu'en février 2027
OS2	D'ici juin 2028, la part des marins côtiers qui sautent au moins un repas par jour en mer passe de 37,0 % à 25 % au plus	Questionnaire de suivi
OO1 (OS1)	D'ici décembre 2027, construire avec la coopérative et trois patrons volontaires trois listes d'avitaillement types pour une marée de 10 jours, intégrant fruits et légumes de bonne conservation, surgelés et conserves de légumes, et les proposer à tous les bateaux du large	3 listes ; nombre de bateaux qui les utilisent (cible : la moitié)

Niveau	Objectif	Indicateur et cible
OO2 (OS1)	D'octobre 2027 à mars 2028, animer 6 ateliers « cuisine de bord » de 2 heures à la Maison des gens de mer, le samedi matin, pour au moins 15 marins-cuisiniers, avec des recettes au réchaud à deux feux	Nombre d'ateliers, de participants, de bateaux représentés
OO3 (OS2)	D'ici novembre 2027, diffuser à tous les marins côtiers une fiche plastifiée « gamelle qui tient au corps » et distribuer 100 sacs isothermes aux volontaires	Nombre de fiches et de sacs distribués
OO4 (OS2)	D'ici septembre 2027, obtenir de la criée l'installation d'un point d'eau sur le quai et l'ajout d'eau, de fruits et de sandwichs au pain complet dans le distributeur	Point d'eau installé ; nombre de produits ajoutés et ventes

Cohérence avec l'arbre à objectifs : OS1 répond aux causes « fruits et légumes absents de l'avitaillement » et « cuisinier non formé » ; OS2 répond aux causes « horaires » et « pas de solution transportable ». Chaque objectif opérationnel sert un objectif spécifique.

Poste	Calcul	Montant
Ateliers cuisine de bord (denrées)	6 × 60 €	360 €
Session avec le lycée maritime (denrées, intervenant)	forfait	500 €
Fiches recettes et listes plastifiées, résistantes à l'eau	400 exemplaires	400 €
Sacs isothermes pour les marins côtiers	100 × 7 €	700 €
Gourdes réutilisables	150 × 4 €	600 €
Communication (affiches criée, coopérative, messages vocaux)	forfait	300 €
Évaluation (questionnaires, saisie)	forfait	150 €
Imprévus	environ 10 %	300 €
Total		**3 310 €** (marge de 190 €)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée

Question 6 – Risques relatifs (1,5 pt)

Calcul posé – Marins du large par rapport aux marins côtiers

Obésité : RR = (18 / 56) / (17 / 92) = 0,3214 / 0,1848 = **1,74**. Erreur type de ln RR : √(1/18 − 1/56 + 1/17 − 1/92) = √(0,05556 − 0,01786 + 0,05882 − 0,01087) = √0,08565 = 0,2927. IC à 95 % : exp(ln 1,74 ± 1,96 × 0,2927) = exp(0,5536 ± 0,5737), soit **[0,98 ; 3,09]**.

Surpoids (obésité comprise) : RR = (41 / 56) / (51 / 92) = 0,7321 / 0,5543 = **1,32**. Erreur type : √(1/41 − 1/56 + 1/51 − 1/92) = √(0,02439 − 0,01786 + 0,01961 − 0,01087) = √0,01527 = 0,1236. IC à 95 % : exp(0,2782 ± 0,2422), soit **[1,04 ; 1,68]**.

Interprétation : chez les répondants, le surpoids est 1,32 fois plus fréquent chez les marins du large que chez les marins côtiers ; l'intervalle de confiance ne contient pas 1, la différence est **statistiquement significative** au seuil de 5 %. Pour l'obésité, le risque relatif observé est plus élevé (1,74), mais l'intervalle contient 1 : la différence **n'est pas significative** avec cet effectif ; cela ne prouve pas l'absence de différence, cela signifie que l'échantillon est trop petit pour conclure. Dans les deux cas, il s'agit d'une association : le type de pêche est lié à d'autres facteurs (âge, conditions de vie, avitaillement), et l'IMC est déclaré.

Question 7 – Précision et nouvelle enquête (1,5 pt)

Calcul posé – Intervalle de confiance et taille d'échantillon

p = 92 / 148 = 0,622 ; e = 1,96 × √(0,622 × 0,378 / 148) = 1,96 × √0,001589 = 1,96 × 0,03986 = 0,0781, soit **± 7,8 points** ; IC à 95 % : **[54,3 % ; 70,0 %]**.

Taille d'échantillon pour ± 5 points (p = 0,62) : n0 = 1,96² × 0,62 × 0,38 / 0,05² = 3,8416 × 0,2356 / 0,0025 = **362,0** ; correction pour N = 312 : n = 362,0 / (1 + 361,0 / 312) = 362,0 / 2,157 = **167,8**, soit **168 marins**.

Même avec la marge d'erreur, plus de la moitié des répondants sont en surpoids : le résultat est solide pour orienter le projet. Pour la nouvelle enquête : échantillon stratifié par type de pêche (environ 106 côtiers et 62 marins du large, en respectant la répartition de la population), recueil sur plusieurs semaines et à différents moments (départ, retour, jours de mauvais temps), questionnaire court relayé par les patrons et la coopérative ; mesure du poids et de la taille par l'infirmière, avec accord, lors de la visite médicale, pour éviter le biais de déclaration ; mêmes questions qu'en 2027 pour comparer.

Partie C – Veille

Question 8 – Organiser la veille (2 pts)

Sources : Santé publique France (recommandations, études Esteban et Albane), Anses (avis sur le travail de nuit et les rythmes, références nutritionnelles), Institut national de recherche et de sécurité (INRS) pour la santé au travail et les horaires atypiques, Haute Autorité de santé, Institut maritime de prévention et services de santé des gens de mer, bases bibliographiques (PubMed, Cairn), portail des interventions probantes de Santé publique France ; presse professionnelle de la pêche pour le contexte. Outils : alertes par mots-clés (« travail de nuit » et « alimentation », « marins-pêcheurs »), abonnements aux lettres d'information, flux RSS, fiche de lecture standardisée (référence, date, apport, limites). Fréquence : une revue hebdomadaire de 30 minutes. Diffusion : dossier partagé de l'association, synthèse mensuelle d'une page pour l'infirmière et le comité de pilotage, rubrique « ce qui marche ailleurs » dans les réunions avec la coopérative.

Partie D – Communication et posture professionnelle

Question 9 – Méthode participative et communication (1,5 pt)

Méthode : une **technique du groupe nominal** ou un **photolangage** organisé avec le comité local des pêches, le samedi matin ou un jour de mauvais temps (bateaux à quai), dans la salle de la criée plutôt qu'à la Maison des gens de mer, pour 6 à 10 marins (patrons, cuisiniers de bord, matelots, une marin femme). Déroulement d'environ 1 heure : question de départ (« Qu'est-ce qui vous empêche de bien manger en mer ? »), réflexion individuelle écrite ou en photos (cales, réchaud, gamelle), tour de table sans débat, regroupement des idées, vote individuel pour classer les cinq idées prioritaires, restitution immédiate. Un café et une collation sont offerts ; la participation est libre et les propos ne sont pas nominatifs.

Communication : partir de ce qui compte pour le public (**force, vigilance, sécurité à bord, tenir la marée**) plutôt que de la « nutrition » ; messages courts et concrets (« Une gamelle qui tient jusqu'au retour », « Des fruits qui tiennent dix jours en cale ») ; porteurs de messages crédibles (un patron respecté, le cuisinier d'un bateau pilote, la coopérative) ; canaux adaptés aux horaires (affiches à la criée et à la coopérative, messages vocaux sur les groupes de messagerie des équipages, fiches dans les colis d'avitaillement) ; pas de discours sur le poids ni d'image culpabilisante.

Question 10 – Exposé et questions du jury (1,5 pt)

Trame de l'exposé (10 minutes) : 1 min, contexte, structure et demande ; 2 min, méthode et résultats du diagnostic (62,2 % de surpoids, 18,2 % de fruits et légumes quotidiens, 37,8 % de repas sautés), biais et comparaison avec Esteban ; 1 min 30, arbre à problèmes et FFOM ; 1 min 30, priorités (Hanlon et PEARL) ; 2 min, objectifs et actions ; 1 min, ce que j'ai réalisé pendant le stage (groupe nominal, première liste d'avitaillement, un atelier) ; 1 min, évaluation prévue, limites et perspectives.

Questions probables du jury : 1. Pourquoi ne pas avoir mesuré le poids ? 2. Votre échantillon est-il représentatif ? 3. Qu'est-ce qu'un redressement ? 4. Comment interprétez-vous un intervalle de confiance qui contient 1 ? 5. Pourquoi l'alcool n'est-il pas votre priorité alors qu'il a le meilleur score ? 6. Qu'est-ce que le test

PEARL ? 7. Différence entre objectif spécifique et objectif opérationnel ? 8. Comment avez-vous associé les marins ? 9. Qu'est-ce qu'un besoin normatif ? 10. Quels fruits et légumes se conservent dix jours à bord ? 11. Comment évaluerez-vous le projet ? 12. Quels partenaires et pourquoi ? 13. Que ferez-vous si la coopérative refuse ? 14. Quelles sources avez-vous utilisées ? 15. Quelles précautions éthiques avez-vous prises ?

Éléments de réponse pour cinq questions :

- **Question 1** : le poids déclaré était plus simple et plus acceptable sur les quais ; c'est une limite (sous-estimation probable), corrigée dans la prochaine enquête par une mesure lors de la visite médicale.
- **Question 4** : l'échantillon ne permet pas de conclure à une différence au seuil de 5 % ; la différence observée peut être due au hasard, mais une vraie différence n'est pas exclue.
- **Question 5** : la prise en charge de l'alcool relève du CSAPA et du médecin ; le problème n'est pas ignoré, il est confié au partenaire compétent avec une action conjointe.
- **Question 10** : pommes, oranges, clémentines, carottes, choux, oignons, pommes de terre, courges ; complétés par des légumes surgelés et en conserve, des fruits secs et des compotes.
- **Question 15** : questionnaire anonyme et facultatif, résultats présentés de façon globale, aucune information individuelle transmise aux patrons ou à la coopérative, discours sans jugement sur le poids, orientation confidentielle vers le CSAPA.

Barème – Barème du temps 1

Partie A : 9 points (indicateurs et comparaison 2 ; redressement et biais 1,5 ; arbre, FFOM et besoins 2 ; priorités 1,5 ; objectifs, actions et budget 2). Partie B : 3 points. Partie C : 2 points. Partie D : 3 points. Expression, vocabulaire et sources datées : 3 points. Total : 20 points.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Comparer directement un IMC déclaré à des mesures nationales sans discuter la méthode ; croire que le redressement corrige tous les biais ; conclure « pas de différence » quand l'intervalle contient 1 ; retenir l'alcool comme priorité nutritionnelle sans partenaire compétent, ou l'ignorer ; proposer des réunions d'information que le public refuse ; écrire des objectifs sans indicateur ni échéance (« sensibiliser les marins à l'équilibre alimentaire ») ; oublier l'environnement alimentaire (avitaillement, distributeur, point d'eau) ; dépasser le budget ou oublier les imprévus.

Corrigé S2 – « Je dois tenir pour lui » : un atelier culinaire pour les parents hébergés près d'un hôpital pédiatrique

> **que le jury attend**
>
> Le jury évalue la rigueur technique (bon de commande, fiche technique, calculs, hygiène des œufs et du plat emporté) et, sur ce sujet, la justesse de la **posture** : des parents épuisés, inquiets pour leur enfant, qui n'ont pas besoin d'une leçon mais de solutions rapides et d'un moment de répit. Il valorise un diagnostic chiffré tiré du document 5, une version « en 20 minutes » réellement faisable avec une seule poêle, des adaptations individuelles discrètes et une organisation qui tient compte des départs imprévus. Il pénalise l'oubli des allergènes (fruits à coque possibles dans les flocons d'avoine, moutarde de la vinaigrette), un conseil de régime pendant l'allaitement, une réponse diététique sur la chimiothérapie d'un enfant que le candidat ne suit pas et des photos de parents identifiables.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Diagnostic, besoins et objectifs (2 pts)

Le taux de réponse est de 26 / 34 = **76,5 %** : il est élevé, mais le questionnaire n'a été proposé que pendant deux semaines aux parents présents, et les parents les plus épuisés ont pu ne pas répondre. Les pourcentages sont calculés sur les 26 répondants.

Réponse	Effectif	Pourcentage des répondants
Au moins un repas par jour au distributeur ou à la cafétéria	17	17 / 26 = 65,4 %
Saute régulièrement le petit déjeuner	15	57,7 %
Saute régulièrement le dîner	9	34,6 %
« Pas le temps » de cuisiner	19	73,1 %
« Ne sait pas cuisiner »	8	30,8 %
Aimerait des recettes prêtes en moins de 20 minutes	21	80,8 %
Dépense plus de 10 € par jour et trouve cela trop cher	12	46,2 %
Un moment entre parents ferait du bien	14	53,8 %

Trois besoins prioritaires se dégagent :

- **gagner du temps** : près des trois quarts des parents n'ont « pas le temps » et 80,8 % veulent des recettes en moins de 20 minutes ;
- **retrouver un rythme de repas et une alimentation moins coûteuse** : deux parents sur trois mangent au distributeur ou à la cafétéria, plus de la moitié sautent le petit déjeuner, et près d'un sur deux trouve son budget trop lourd ;
- **souffler et rompre l'isolement** : plus de la moitié des répondants souhaitent un moment entre parents.

Le besoin de « savoir cuisiner » (30,8 %) est réel mais secondaire : on y répond par des gestes simples, sans en faire le cœur de l'atelier.

Objectif général : permettre aux parents hébergés de préparer en peu de temps des repas complets, économiques et rassasiants, adaptés à leur rythme de vie à l'hôpital, et de partager un moment de répit.

Objectifs opérationnels, mesurés à la fin de la séance :

- chaque parent **réalise** avec son binôme au moins une étape du repas (frittata, carottes râpées ou crumble) ;
- chaque parent **cite** une idée de repas prêt en moins de 20 minutes avec une seule poêle, à partir de la fiche recette distribuée ;
- chaque parent **repart** avec une portion conditionnée et étiquetée selon le règlement de la maison, et **indique** sur une échelle de 1 à 5 s'il se sent capable de refaire la recette (objectif : au moins 6 parents sur 8 répondent 4 ou 5).

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Denrée	Net pour 10	Perte	Brut pour 10	Unité de commande	Coût
Pommes de terre	1 200 g	15 %	1 200 / 0,85 = 1 411,8 g	1,412 kg	1,412 × 1,40 = 1,98 €
Épinards hachés surgelés	600 g	0 %	600 g	0,6 kg	0,6 × 2,90 = 1,74 €
Oignons	200 g	10 %	200 / 0,9 = 222,2 g	0,222 kg	0,222 × 1,80 = 0,40 €
Œufs	15 œufs (750 g)	0 %	15 œufs	15 pièces	15 × 0,25 = 3,75 €
Emmental râpé	150 g	0 %	150 g	0,15 kg	0,15 × 9,90 = 1,49 €
Lait demi-écrémé	200 g	0 %	200 g	0,2 L	0,2 × 1,05 = 0,21 €
Huile d'olive	50 g	0 %	50 g	0,05 kg	0,05 × 8,50 = 0,43 €
Carottes	600 g	15 %	600 / 0,85 = 705,9 g	0,706 kg	0,706 × 1,50 = 1,06 €
Huile de colza	40 g	0 %	40 g	0,04 kg	0,04 × 3,20 = 0,13 €
Pain de campagne	400 g	0 %	400 g	0,4 kg	0,4 × 4,20 = 1,68 €
Pommes	800 g	20 %	800 / 0,8 = 1 000 g	1 kg	1 × 2,40 = 2,40 €
Poires	600 g	20 %	600 / 0,8 = 750 g	0,75 kg	0,75 × 2,90 = 2,18 €
Flocons d'avoine	120 g	0 %	120 g	0,12 kg	0,12 × 2,20 = 0,26 €
Farine T55	100 g	0 %	100 g	0,1 kg	0,1 × 1,10 = 0,11 €
Beurre doux	80 g	0 %	80 g	0,08 kg	0,08 × 9,80 = 0,78 €
Sucre blanc	60 g	0 %	60 g	0,06 kg	0,06 × 1,20 = 0,07 €
Cannelle, vinaigre, moutarde, muscade, sel, poivre	–	–	–	forfait	0,80 €
Total					**19,46 €**

Le total est calculé sur les coûts non arrondis (somme des lignes : 18,66 € ; avec le forfait : 19,46 €). Coût par portion : 19,46 / 10 = **1,95 €** (1,946 €), inférieur au budget de 2,20 € : le budget est respecté, avec une marge de 0,25 € par portion, soit environ 2,50 € pour l'atelier. Les œufs sont le premier poste de dépense : 3,75 / 19,46 = **19,3 %** du coût. La marge peut financer l'enrichissement prévu pour Madame D. et un fromage blanc pour Madame A.

Question 3 – Fiches techniques, version rapide, adaptations et portion à emporter (3 pts)

Fiche technique – Frittata aux pommes de terre, épinards et emmental ; carottes râpées ; pain (10 portions)

Ingrédients : pommes de terre 1,412 kg brutes ; épinards hachés surgelés 600 g ; oignons 222 g bruts ; 15 œufs ; emmental râpé 150 g ; lait demi-écrémé 200 g ; huile d'olive 50 g ; muscade, poivre, sel ; carottes 706 g brutes ; vinaigrette (huile de colza 40 g, vinaigre, moutarde) ; pain de campagne 400 g.

Matériel : 2 plats à four rectangulaires (environ 25 × 30 cm), 2 sauteuses, 1 casserole, 2 saladiers, 1 cul-de-

poule réservé au cassage des œufs, fouets, planches et couteaux comptés, 2 râpes, éplucheurs, balance, verre doseur, thermomètre à sonde, gants de four, boîtes alimentaires fermées et étiquettes.

Étapes : 1. Se laver les mains ; laver, éplucher et tailler les pommes de terre en dés de 1 cm ; ciseler les oignons. 2. Cuire les dés 10 minutes à l'eau bouillante (ou 8 minutes au four à micro-ondes, couverts, avec un fond d'eau) ; égoutter. 3. Faire revenir les oignons dans l'huile d'olive, ajouter les épinards encore surgelés et laisser évaporer l'eau 5 minutes. 4. Casser les œufs un par un dans un bol, puis les verser dans le cul-de-poule ; se laver les mains après avoir touché les coquilles ; battre avec le lait, la muscade, le poivre et la moitié de l'emmental. 5. Répartir pommes de terre et épinards dans les plats huilés, verser les œufs, parsemer du reste d'emmental. 6. Cuire 25 minutes au four à 180 °C, jusqu'à ce que le centre soit pris et ne soit plus baveux ; contrôler au thermomètre à sonde. 7. Pendant la cuisson, râper les carottes et préparer la vinaigrette ; assaisonner au dernier moment. 8. Couper la frittata en 10 parts ; servir avec les carottes râpées et le pain.

Points critiques : œufs cassés à part et coquilles jetées aussitôt ; cuisson à cœur ; épinards bien égouttés (sinon la frittata rend de l'eau) ; vinaigrette sans moutarde servie à part si un participant est allergique à la moutarde ; portion à emporter refroidie rapidement.

Fiche technique – Crumble pommes-poires aux flocons d'avoine (10 portions)

Ingrédients : pommes 1 kg brutes ; poires 750 g brutes ; flocons d'avoine 120 g (étiquette vérifiée : sans mention « traces de fruits à coque ») ; farine T55 100 g ; beurre doux 80 g ; sucre 60 g ; cannelle 3 g.

Matériel : 1 grand plat à four, 1 saladier, planches et couteaux, éplucheurs, balance.

Étapes : 1. Laver, éplucher et couper les fruits en dés ; les répartir dans le plat avec la cannelle. 2. Sabler du bout des doigts la farine, les flocons, le beurre coupé en dés et le sucre. 3. Recouvrir les fruits de cette pâte sablée. 4. Cuire 25 minutes à 180 °C, sur l'étage du dessous, en même temps que les frittatas. 5. Servir tiède.

Points critiques : contrôle de l'étiquette des flocons, de la farine et du sucre pour les fruits à coque ; aucune poudre d'amande ni noisette dans la cuisine ce jour-là ; part de Monsieur K. préparée à part, sans sucre ajouté.

Les deux préparations cuisent à la même température (180 °C) : un seul four suffit, en deux étages, ce qui respecte le temps de 1 h 30.

Version « en 20 minutes avec une seule poêle » (2 portions, le soir dans la cuisine de la maison) :

1. Couper 2 pommes de terre en petits dés (ou utiliser des pommes de terre cuites la veille) ; les cuire 10 minutes dans la poêle avec une cuillère d'huile, à couvert, en remuant.
2. Ajouter une poignée d'épinards surgelés, laisser évaporer 3 minutes.
3. Verser 3 œufs battus avec un peu de lait et d'emmental ; cuire 6 à 8 minutes à feu doux, à couvert, jusqu'à ce que le dessus soit pris ; retourner à l'aide d'une assiette si on le souhaite.
4. Pendant la cuisson, râper une carotte et l'assaisonner.
5. Dessert sans poêle : une pomme coupée en dés, cannelle, 2 minutes au four à micro-ondes, avec une cuillère de flocons d'avoine et un yaourt nature.

On montre que la même base se décline (pommes de terre déjà cuites, légumes surgelés, œufs, fromage) et qu'un repas complet coûte bien moins que les 10 € par jour déclarés par 46,2 % des répondants.

Adaptations individuelles, proposées discrètement, sans les annoncer devant le groupe :

- **Madame A. (allaitement)** : aucune restriction ni « régime » ; elle mange à sa faim. On l'encourage à garder une carafe ou une gourde d'eau à portée de main et à boire selon sa soif (repère PNNS, document 7). On lui propose un laitage en plus (fromage blanc ou yaourt) pour compléter le calcium. On ne commente pas son poids.
- **Madame D. (perte de 6 kg, « plus faim »)** : portion enrichie sans augmenter le volume (15 g d'emmental et 20 g de lait en plus dans sa part, voir question 4) ; fractionnement : la portion emportée peut être mangée en

deux fois, en collation ; on privilégie le plaisir et la texture qu'elle aime. On l'invite, en privé, à parler de sa perte de poids et de sa fatigue à son médecin traitant ou au psychologue mis à disposition par l'hôpital ou l'association : ce n'est pas le rôle de l'atelier de la prendre en charge.

- **Monsieur K. (diabète de type 2)** : le repas répartit des glucides complexes (pommes de terre, pain, flocons) avec des fibres ; on lui propose sa part de crumble sans sucre ajouté (préparée dans un petit plat à part) et on rappelle de garder le pain et les pommes de terre au repas, plutôt qu'en grignotage. On ne modifie pas son traitement et on ne parle pas de sa glycémie devant les autres.
- **Madame T. (allergie aux fruits à coque)** : vérification de toutes les étiquettes avant l'atelier (flocons d'avoine, farine, pain de campagne, emmental râpé) ; refus de tout produit portant la mention « peut contenir des traces de fruits à coque » ; aucune autre préparation de la maison contenant des fruits à coque sur le plan de travail ; ustensiles lavés avant l'atelier. La liste des allergènes du repas est affichée (règlement INCO, document 7).
- **Madame S. (végétarienne) et Monsieur B. (sans porc)** : le menu ne contient ni viande ni porc ; aucune adaptation n'est nécessaire, ce qu'on peut leur confirmer en privé.

Portion à emporter à l'hôpital le lendemain : la part est découpée dès la sortie du four, placée dans une boîte peu profonde qui ferme, laissée tiédir à couvert quelques minutes puis mise au réfrigérateur sans attendre (au plus 4 °C). L'étiquette indique le nom du parent, le contenu, la date de préparation, la date limite (J + 2, conformément au règlement de la maison) et les allergènes (œufs, lait, gluten ; moutarde si la vinaigrette est jointe). Le lendemain, la boîte voyage dans un sac isotherme avec un pain de glace ; elle est réchauffée au four à micro-ondes jusqu'à ce que le plat soit très chaud à cœur, ou mangée froide si elle est restée au frais. Les carottes sont emportées sans vinaigrette, assaisonnées au moment du repas. On vérifie auprès du service que le parent peut manger dans l'espace des familles.

Question 4 – Apports d'une portion (2 pts)

Apport par portion	Frittata, carottes, pain	Crumble	Repas complet
Énergie	490,35 kcal	241,35 kcal	**731,7 kcal**
Protéines	22,50 g	2,65 g	25,16 g
Glucides	45,50 g	37,08 g	82,57 g
dont sucres	7,31 g	20,65 g	27,96 g
Lipides	21,98 g	8,04 g	30,03 g
Fibres	8,22 g	4,68 g	12,9 g
Sel	1,00 g	0,01 g	1,01 g
Calcium	358,43 mg	21,49 mg	379,92 mg
Fer	3,99 mg	0,71 mg	4,7 mg
Vitamine C	36,16 mg	6,27 mg	42,43 mg

Calcul posé – Exemples de calcul et répartition de l'énergie

Œufs : 75 g × 140 / 100 = 105 kcal ; 75 × 12,8 / 100 = 9,6 g de protéines. Emmental : 15 g × 977 / 100 = 146,55 mg de calcium. Pain : 40 g × 1,18 / 100 = 0,47 g de sel.

Répartition de l'énergie : protéines 25,16 × 4 = 100,6 kcal, soit 100,6 / 731,7 = **13,8 %** ; lipides 30,03 × 9 = 270,3 kcal, soit **36,9 %** ; glucides 82,57 × 4 = 330,3 kcal, soit **45,1 %** (le reste, environ 3,5 %, vient des fibres, comptées 2 kcal par gramme).

Sucres ajoutés : 6 g de sucre blanc × 3,99 kcal = 23,9 kcal, soit 23,94 / 731,7 = **3,3 %** de l'énergie du repas.

Commentaire :

- Le repas est **complet et rassasiant** : 731,7 kcal, des protéines en quantité (25 g, surtout des œufs et de l'emmental), des féculents (pommes de terre, pain, avoine), des légumes et des fruits. On compte environ

trois portions de fruits et légumes (épinards et carottes, pommes et poires), ce qui aide à approcher le repère « au moins cinq par jour » de Santé publique France.

- La répartition est équilibrée ; les lipides (36,9 %) viennent surtout des œufs, de l'emmental, de l'huile et du beurre, avec une part d'huiles d'olive et de colza intéressante pour la qualité des acides gras.
- Les sucres ajoutés ne représentent que 3,3 % de l'énergie, très en dessous du repère OMS de 10 % ; les autres sucres viennent surtout des fruits.
- Les fibres (12,9 g) sont élevées pour un repas, grâce aux légumes, aux fruits avec leur peau et aux flocons d'avoine. Le sel (1,01 g, hors sel ajouté) est modéré.
- **Calcium** : 379,92 mg, soit 40,0 % des 950 mg conseillés par jour à l'adulte de 25 ans et plus (Anses 2021) en un seul repas. **Vitamine C** : 42,43 mg, soit 38,6 % des 110 mg conseillés.
- **Pour Madame A.**, qui allaite : le repas lui apporte un bon tiers de ses besoins en calcium et en vitamine C ; il est varié et sans restriction, comme le conseille le PNNS. On complète par un laitage et de l'eau à volonté ; elle mange selon sa faim.
- **Pour Madame D.** : l'enrichissement de 15 g d'emmental et 20 g de lait apporte 64,48 kcal, 4,78 g de protéines et 170,35 mg de calcium. Son repas passe à **796,2 kcal**, 29,94 g de protéines et 550,3 mg de calcium, pour un volume presque identique. Le fractionnement (portion emportée mangée en deux fois) l'aide quand l'appétit manque.
- **Pour Monsieur K.**, le crumble sans sucre ajouté ramène les sucres du repas à 21,98 g et les glucides à 76,59 g (707,8 kcal).

Question 5 – Cadre de l'atelier (2 pts)

> **Exemple – Le cadre énoncé au début de l'atelier**
>
> « Bonjour et merci d'être là. Pendant une heure et demie, on va cuisiner ensemble un repas complet qui coûte moins de 2 euros, et je vais vous montrer comment le faire en 20 minutes avec une seule poêle. Ici, vous êtes libres : vous participez comme vous le souhaitez, vous pouvez partir à tout moment si le service vous appelle, et votre portion vous attendra au réfrigérateur avec votre nom. Ce qui se dit autour de cette table reste entre nous. Je suis diététicienne : je peux vous donner des idées pour vos repas à vous, mais pour l'alimentation de vos enfants, ce sont les équipes de leur service qui savent. Personne ne sera photographié sans son accord. »

- **Accueil** : prénoms, café ou eau à disposition, présentation de la bénévole ; aucune question sur l'enfant ou sa maladie.
- **Confidentialité entre parents** : on ne répète pas à l'extérieur ce qu'un parent a confié ; le candidat ne transmet aucune information à l'association sans l'accord du parent, sauf danger.
- **Liberté** : participation libre, droit de ne rien goûter, départ possible à tout moment sans justification.
- **Limites du rôle** : le candidat n'est ni le médecin ni la diététicienne des enfants ; il oriente vers l'équipe soignante du service, vers le médecin traitant du parent ou vers le soutien psychologique proposé par l'hôpital ou l'association.
- **Droit à l'image** : la présence d'un parent à la Maison des familles révèle qu'un enfant est hospitalisé ; on ne photographie pas les parents identifiables, et toute photo de plats ou de mains suppose un accord écrit.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté des 3 heures (2 pts)

Horaire	Candidat	Parents
13 h 00 – 13 h 40	Finalise la fiche technique et les fiches recettes imagées ; vérifie les étiquettes (fruits à coque) ; pèse les denrées par poste.	–

Horaire	Candidat	Parents
13 h 40 – 14 h 00	Met en place 4 postes (pommes de terre et épinards ; œufs et assemblage ; crumble ; carottes et vinaigrette) ; préchauffe le four à 180 °C ; prépare boîtes et étiquettes.	–
14 h 00 – 14 h 10	Accueil, cadre, présentation du menu et du déroulé.	S'installent, choisissent un poste.
14 h 10 – 14 h 35	Démonstration des gestes clés (dés, cassage des œufs, sablage) puis circulation entre les binômes.	Lavent, épluchent, taillent, cuisent les pommes de terre ; préparent le crumble.
14 h 35 – 14 h 40	Contrôle l'assemblage ; enfourne les deux frittatas et le crumble.	Assemblent les frittatas.
14 h 40 – 15 h 05	Démonstration de la version « 20 minutes, une poêle » (2 parts, goûtées ensuite) ; anime l'échange sur les repas à l'hôpital et les astuces de chacun.	Râpent les carottes ; préparent la vinaigrette ; participent à l'échange ; rangent leur poste.
15 h 05 – 15 h 20	Contrôle la cuisson à cœur ; découpe ; dresse une assiette témoin ; anime la dégustation.	Dégustent ; remplissent la grille de dégustation.
15 h 20 – 15 h 30	Conditionne et étiquette les portions à emporter ; recueille l'évaluation ; remet les fiches recettes.	Rangent leur boîte dans leur étagère ; répondent à l'évaluation.
15 h 30 – 16 h 00	Remise en état, nettoyage et désinfection, tri des déchets, bilan écrit avec la bénévole.	–

Départ possible de deux parents : chaque tâche est confiée à un binôme, et non à une seule personne, pour que la tâche continue si un parent part ; la bénévole prend le relais si besoin. Le parent qui part reçoit sa fiche recette ; sa portion est conditionnée, étiquetée à son nom et rangée sur son étagère ; il peut répondre à l'évaluation plus tard (fiche laissée dans sa boîte aux lettres). On ne lui demande aucune explication.

Question 7 – Méthodes, outils et grille de dégustation (1,5 pt)

- **Démonstration courte** des gestes clés, puis « faire avec » : le candidat ne fait pas à la place des parents, surtout pour Monsieur P. qui n'a « jamais cuisiné » et qu'on place en binôme avec un parent plus à l'aise.
- **Binômes** sur quatre postes, avec une fiche de poste en images (étapes numérotées, quantités en cuillères et en verres).
- **Fiche recette imagée** à emporter : la recette de l'atelier, la version « 20 minutes », trois variantes (courgettes, petits pois, restes de légumes) et une liste de courses type à moins de 10 € pour deux jours.
- **Échange sur les repas à l'hôpital** : « Qu'est-ce que vous mangez quand vous êtes dans le service ? » ; on recueille les astuces des parents (boîte préparée la veille, fruits dans le sac) plutôt que de donner des consignes.
- **« Faire dire »** : à la fin, chaque parent cite une idée de repas rapide qu'il pourrait faire ce soir.

Grille de dégustation	J'aime	Moyen	Je n'aime pas
Frittata			
Carottes râpées			
Crumble			
Je pourrais le refaire ici, le soir	oui	peut-être	non

Question 8 – Hygiène, sécurité, allergènes et éco-gestes (1,5 pt)

- **5 M** : *main-d'œuvre* (lavage des mains à l'arrivée, après les coquilles d'œufs et après chaque passage aux toilettes ; cheveux attachés ; tablier ; pansement sur une plaie) ; *milieu* (plans de travail nettoyés et désinfectés avant et après) ; *matériel* (planches et couteaux propres, thermomètre désinfecté entre deux

mesures) ; *matières* (dates vérifiées, surgelés gardés au congélateur jusqu'à l'utilisation, produits frais au réfrigérateur) ; *méthode* (marche en avant, séparation des tâches sales et propres).

- **Œufs** : stockés au réfrigérateur ; cassés un par un dans un bol puis versés dans le cul-de-poule ; coquilles jetées aussitôt ; mains lavées après ; préparation cuite à cœur (centre pris, plus baveux), contrôlée à la sonde.
- **Refroidissement et conservation** : portions découpées et mises en boîtes peu profondes, au réfrigérateur sans attendre (au plus 4 °C) ; étiquette avec nom, contenu, date de préparation, date limite à J + 2 et allergènes ; transport en sac isotherme ; réchauffage jusqu'à ce que le plat soit très chaud à cœur.
- **Sécurité** : gants de four ; plats sortis par le candidat ; couteaux comptés au début et à la fin, posés à plat ; manche des casseroles tourné vers l'intérieur ; sol essuyé immédiatement.
- **Allergènes** : liste affichée (œufs, lait, gluten du pain, de la farine et de l'avoine, moutarde de la vinaigrette) ; étiquettes vérifiées pour les fruits à coque (Madame T.) ; vinaigrette servie à part.
- **Trois éco-gestes** : épluchures de pommes et de poires réduites (fruits lavés et gardés avec leur peau dans d'autres recettes) ; épluchures compostées si la maison dispose d'un composteur ; boîtes réutilisables plutôt que du film plastique ; four allumé une seule fois pour les trois plats ; eau de lavage économisée.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (3 pts)

Le jury observe : l'organisation du poste et la marche en avant ; la conduite des binômes (le candidat guide et ne fait pas à la place) ; la maîtrise de la cuisson des frittatas et du crumble en un seul passage au four ; le respect du temps ; le dressage d'une assiette (une part de frittata dorée, un petit tas de carottes râpées assaisonnées, une tranche de pain) et d'une part de crumble tiède ; le conditionnement et l'étiquetage d'une portion à emporter ; la remise en état du poste.

Question 10 – Évaluation et trois situations (1 pt)

Évaluation de l'atelier : grille de dégustation ; échelle de 1 à 5 « je me sens capable de refaire cette recette » ; question « allez-vous la refaire dans les jours qui viennent ? » (oui, peut-être, non) ; échelle de 1 à 5 « cet atelier m'a fait du bien » ; recueil d'une idée de thème pour un prochain atelier. Quinze jours plus tard, la bénévole demande aux parents encore hébergés s'ils ont refait la recette ou la version rapide. Le bilan à l'association ne contient aucune donnée nominative.

- **Madame D. pleure** : on s'arrête, on se met à côté d'elle, on l'écoute sans minimiser (« C'est normal d'être épuisée, vous traversez quelque chose de très dur »). On lui propose de faire une pause dans une pièce calme avec la bénévole, ou de rester et de continuer à son rythme. Après l'atelier, en privé, on lui rappelle l'existence du soutien psychologique proposé par l'hôpital ou l'association et on l'invite à parler de sa perte de poids à son médecin. Réponse : « Vous n'avez pas à réussir quoi que ce soit aujourd'hui. Vous êtes là, c'est déjà beaucoup. On peut faire une pause, et si vous le voulez, je vous donnerai le contact de la psychologue. »
- **Le père qui demande ce que doit manger son fils pendant la chimiothérapie** : on ne donne pas de conseil alimentaire pour un enfant que l'on ne suit pas et dont on ne connaît ni le traitement ni l'état ; on oriente vers l'équipe du service, qui comprend souvent une diététicienne. Réponse : « Votre question est très importante. Pendant une chimiothérapie, l'alimentation dépend du traitement et de l'état de votre fils : je ne peux pas vous répondre sans le connaître. Demandez à l'infirmière du service à rencontrer la diététicienne de pédiatrie ; vous pouvez préparer vos questions par écrit, je peux vous aider à les noter. »
- **Les photos demandées par la présidente** : on refuse les photos de parents identifiables (leur présence révèle l'hospitalisation d'un enfant, donnée sensible) ; on propose des photos des plats, des mains et de la cuisine, avec l'accord écrit des parents concernés, et un témoignage anonyme pour le dossier de subvention. Réponse : « Je comprends l'intérêt pour l'association. Je vous propose des photos des plats et des mains, sans visage, et un témoignage anonyme : ici, montrer un parent, c'est dire que son enfant est hospitalisé. »

Barème – Barème du temps 2

Partie 1 : 11 points (diagnostic, besoins et objectifs 2 ; bon de commande 2 ; fiches techniques, version rapide, adaptations et portion à emporter 3 ; apports 2 ; cadre 2). Partie 2 : 5 points (déroulé 2 ; méthodes et dégustation 1,5 ; hygiène, sécurité, allergènes, éco-gestes 1,5). Partie 3 : 4 points (réalisation 3 ; évaluation et

situations 1). Total : 20 points.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages du document 5 sur les 34 parents hébergés au lieu des 26 répondants ; oublier les pertes des pommes de terre, des oignons, des carottes et des fruits ; compter 1,5 œuf comme 1 œuf dans le bon de commande ; proposer une version « rapide » qui demande le four ou deux poêles ; conseiller à Madame A. de « faire attention » à son poids ou de limiter certains aliments ; présenter une « assiette diabétique » à Monsieur K. devant le groupe ; oublier la moutarde de la vinaigrette dans la liste des allergènes ou ne pas vérifier les traces de fruits à coque des flocons ; laisser la portion emportée tiédir des heures avant de la ranger ; répondre à la question sur la chimiothérapie ; accepter des photos de parents.

Corrigé S3 – « Au camping toute l'année, mais personne ne le sait » : diagnostic participatif et atelier culinaire avec les habitants permanents d'un camping

que le jury attend

Au temps 1, le jury attend un diagnostic chiffré et prudent (petits effectifs, ménages non rencontrés), une analyse de l'environnement alimentaire qui ne réduit pas la situation à des « comportements » individuels, des priorités justifiées, des objectifs SMART reliés au diagnostic et un budget exact. Il valorise la participation des habitants (habitante relais, méthode participative) et la discrétion imposée par le contexte. Au temps 2, il attend un atelier réellement faisable avec deux réchauds et sans réfrigérateur, une maîtrise du risque *Bacillus cereus* lié au riz cuit, la sauce soja repérée comme source de sel et de gluten, et une évaluation sans écrit obligatoire. Il pénalise un discours culpabilisant, les photos ou les noms d'habitants, et un budget qui dépasse 2 000 €.

Temps 1 – Le projet d'intervention

Question 1 – Participation et indicateurs du diagnostic (2 pts)

Calcul posé – Taux de participation et pourcentages (n = 41 ménages)

Taux de participation : 41 / 52 = **78,8 %** des ménages.

Réchaud à deux feux sans four : 29 / 41 = **70,7 %**. Réfrigérateur de moins de 100 litres : 33 / 41 = **80,5 %**. Sans voiture en état de marche : 17 / 41 = **41,5 %**. Fruits ou légumes moins de cinq fois par semaine : 22 / 41 = **53,7 %**. Au moins un repas sauté le mois dernier par manque d'argent : 14 / 41 = **34,1 %**. Fréquente la distribution de colis : 9 / 41 = **22,0 %**. Souhaite des ateliers « cuisine simple au réchaud » : 26 / 41 = **63,4 %**.

Lecture : plus d'un ménage sur trois a sauté un repas faute d'argent le mois dernier, mais seulement 22,0 % vont à la distribution de colis. L'écart suggère un problème d'accès (horaires du bus, crainte d'être repéré) plutôt qu'une absence de besoin. Les contraintes d'équipement (70,7 % sans four, 80,5 % avec un petit réfrigérateur) expliquent la faible consommation de fruits et légumes frais, ce que confirme Sandra (document 3). La demande d'ateliers est forte (63,4 %) : c'est un levier pour démarrer.

Pourquoi des entretiens au domicile plutôt qu'un questionnaire dans les boîtes aux lettres : le public évite les institutions et l'écrit peut être un obstacle ; un questionnaire déposé aurait eu un faible taux de retour et aurait surtout touché les ménages les plus à l'aise avec l'écrit. L'entretien, mené par une personne connue (l'habitante relais) avec la travailleuse sociale, crée la confiance, permet d'expliquer la démarche, de reformuler les questions et de recueillir des paroles (document 3). Il visait tous les ménages : c'est un recueil exhaustif et non un échantillon.

Les 11 ménages non rencontrés (21,2 %) sont des refus ou des absences. Ils peuvent être les plus isolés ou les plus méfiants, donc peut-être les plus en difficulté : les pourcentages risquent de **sous-estimer** les difficultés réelles. On le signale comme une limite et on prévoit de leur proposer un autre contact (passage de l'habitante relais, invitation à l'atelier).

Question 2 – Croisement selon l'âge et risque relatif (1,5 pt)

Calcul posé – Repas sauté par manque d'argent selon l'âge

Moins de 60 ans : a = 11 sur 25 (b = 14), soit 11 / 25 = **44,0 %**. 60 ans et plus : c = 3 sur 16 (d = 13), soit 3 / 16 = **18,75 %**.

RR = 0,440 / 0,1875 = **2,35**. ln RR = 0,853.

Erreur type : √(1/11 − 1/25 + 1/3 − 1/16) = √0,3217 = 0,567.

IC à 95 % : exp(0,853 ± 1,96 × 0,567) = exp(−0,259) à exp(1,965), soit **[0,77 ; 7,13]**.

Interprétation prudente : les adultes de moins de 60 ans semblent 2,35 fois plus souvent concernés que les 60 ans et plus. Mais l'intervalle de confiance contient 1 : la différence **n'est pas statistiquement significative**, ce qui s'explique par les très petits effectifs (3 cas seulement chez les 60 ans et plus). Il s'agit d'une tendance à confirmer. Elle reste plausible : les moins de 60 ans vivent souvent avec le RSA ou l'AAH, parfois avec des enfants, alors que les plus âgés ont une petite retraite régulière. Les personnes âgées peuvent aussi moins déclarer un repas sauté. On en tire une piste : prévoir des actions qui touchent aussi les familles et les saisonniers, sans oublier l'isolement des plus âgés.

Question 3 – Environnement alimentaire, arbre à problèmes et besoins selon Bradshaw (2 pts)

Dimension	Constat	Source
Accès physique	Camping à 9 km des commerces ; épicerie fermée d'octobre à mai ; 41,5 % des ménages sans voiture ; trois bus par jour en semaine ; bus du mardi décalé par rapport aux colis	Documents 1, 2, 3
Accès économique	Revenus faibles (petites retraites, RSA, AAH) ; 34,1 % ont sauté un repas faute d'argent ; coût du trajet en bus (2,40 € aller-retour)	Documents 1, 2
Offre	Pas d'offre alimentaire sur place en hiver ; colis une fois par mois seulement ; jardin partagé de la commune peu accessible	Documents 1, 3
Équipement	70,7 % avec un réchaud à deux feux et sans four ; 80,5 % avec un réfrigérateur de moins de 100 litres : peu de place pour les produits frais	Document 2
Facteurs sociaux	Crainte d'être repéré, évitement des services publics, solidarité entre voisins	Documents 1, 3

Arbre à problèmes.

- Problème central : une alimentation insuffisante et peu diversifiée chez les habitants permanents du camping (34,1 % ont sauté un repas faute d'argent ; 53,7 % mangent des fruits ou légumes moins de cinq fois par semaine).
- Causes : revenus faibles ; éloignement des commerces et transports limités ; horaires du bus incompatibles avec les colis ; équipement de cuisine et de conservation réduit ; peur d'être repéré, qui éloigne des aides ; savoir-faire culinaire adapté au réchaud peu partagé.
- Conséquences : alimentation monotone (pâtes, conserves, œufs) ; risque de carences et de déséquilibre ; dépendance aux réserves en hiver ; isolement social ; recours tardif aux aides.

Type de besoin (Bradshaw)	Exemple dans ce diagnostic
Normatif	53,7 % des ménages sont loin du repère « au moins cinq fruits et légumes par jour » (Santé publique France, 2019)
Ressenti	« Les légumes frais, je n'ai pas la place de les garder » (Sandra) ; « On vit sur les réserves » (Gérard)
Exprimé	26 ménages (63,4 %) demandent des ateliers « cuisine simple au réchaud » ; Martine souhaite « cuisiner avec d'autres »
Comparatif	Seulement 22,0 % vont aux colis alors que 34,1 % ont sauté un repas ; la comparaison avec la population de la commune ou avec des données nationales sur l'insécurité alimentaire reste à documenter avec une source datée (on n'invente pas de chiffre)

Question 4 – FFOM, priorités et problématique (1,5 pt)

	Positif	Négatif
Interne au projet	Forces : habitante relais connue et acceptée ; forte demande d'ateliers ; salle commune disponible ; travailleuse sociale présente chaque semaine	Faiblesses : budget limité (2 000 €) ; stage de 8 semaines seulement ; salle sans four ni réfrigérateur
Environnement	Opportunités : banque alimentaire départementale ; jardin partagé ; PNNS 5 (2026-2030) et article L. 266-1 du CASF qui soutiennent l'accès à l'alimentation dans la dignité	Menaces : crainte du gérant et des habitants d'être exposés ; épicerie fermée l'hiver ; dépendance aux horaires du bus

Critères de choix : ampleur (nombre de ménages concernés), gravité (repas sautés), faisabilité avec 2 000 € et les moyens disponibles, demande des habitants, équité (atteindre les plus éloignés des aides).

- **Priorité 1 : l'accès aux denrées** (colis et courses). Ampleur et gravité élevées (34,1 % de repas sautés, 41,5 % sans voiture, 22,0 % seulement aux colis) ; faisable par une organisation (navette ou covoiturage solidaire les jours de colis, horaires négociés, commande groupée) ; forte équité.
- **Priorité 2 : cuisiner varié avec un réchaud et un petit réfrigérateur**. Demande exprimée par 63,4 % des ménages ; contraintes d'équipement très fréquentes (70,7 % et 80,5 %) ; faisable avec des ateliers à faible coût.

Problématique : comment améliorer, dans le respect de leur discrétion et de leur dignité, l'accès des habitants permanents du camping à une alimentation suffisante et diversifiée, alors que l'éloignement, les faibles revenus et l'équipement réduit limitent leurs achats et leur cuisine ?

Question 5 – Objectifs, actions, calendrier et budget (2 pts)

Objectif général : améliorer l'accès à une alimentation suffisante, diversifiée et favorable à la santé des habitants permanents du camping « Les Pins de l'Estuaire », d'ici un an, dans des conditions qui respectent leur dignité.

Objectifs spécifiques (changements attendus chez les habitants, SMART) :

- OS1 : d'ici mars 2028, le nombre de ménages du camping qui fréquentent la distribution de colis passe de 9 à au moins 15 (registre anonyme tenu par le CCAS) ;
- OS2 : d'ici mars 2028, la proportion de ménages qui mangent des fruits ou des légumes moins de cinq fois par semaine passe de 53,7 % à moins de 45 % (second recueil par entretiens), et au moins 60 % des participants aux ateliers déclarent avoir refait au moins une recette chez eux (bilan oral recueilli par l'habitante relais).

Objectifs opérationnels (ce que l'équipe réalise, SMART) :

- OO1 : d'ici juin 2027, obtenir de la mairie et de la banque alimentaire un horaire de distribution des colis compatible avec le bus du mardi (compte rendu de réunion).
- OO2 : de juin 2027 à mars 2028, organiser chaque mois un transport solidaire vers la distribution de colis (10 trajets aller-retour au moins).
- OO3 : d'avril 2027 à mars 2028, animer 8 ateliers « cuisine au réchaud » dans la salle commune, avec au moins 8 participants en moyenne (feuille de présence par prénom ou par numéro, détruite après le bilan).
- OO4 : d'ici septembre 2027, concevoir avec les habitants et remettre aux 52 ménages un livret de 20 recettes « au réchaud » à moins de 1,50 € la portion.

OO1 et OO2 servent OS1 ; OO3 et OO4 servent OS2.

Période	Actions
Avril – mai 2027	Restitution du diagnostic aux habitants (réunion conviviale) ; photolangage ; premier atelier ; contact avec la banque alimentaire et la mairie pour les horaires des colis
Juin – septembre 2027	Ateliers 2 à 4 (dont un avec les légumes du jardin partagé) ; mise en place du transport solidaire ; rédaction et diffusion du livret
Octobre 2027 – février 2028	Ateliers 5 à 7, centrés sur les réserves de placard et les surgelés pour l'hiver ; commande groupée mensuelle

Période	Actions
Mars 2028	Atelier 8 et repas partagé ; second recueil par entretiens ; bilan avec les habitants, le CCAS et les financeurs

Poste	Calcul	Montant
Denrées des 8 ateliers	8 × 12 portions × 1,80 € = 172,80 €	175 €
Petit matériel pour la salle (2 faitouts, 2 poêles, ustensiles, thermomètre)	devis estimé	250 €
Transport solidaire vers les colis (tickets de bus ou défraiement de covoiturage)	10 personnes × 2 trajets × 1,20 € × 10 mois	240 €
Boîtes de conservation et sacs isothermes pour les ménages	26 ménages × 8 €	208 €
Jardin partagé (graines, plants, bacs)	forfait	150 €
Livret de recettes (conception avec les habitants, impression de 100 exemplaires)	devis estimé	300 €
Formation et défraiement de l'habitante relais (hygiène, animation)	forfait	200 €
Repas partagé de clôture et convivialité	forfait	150 €
Évaluation (supports du second recueil)	forfait	50 €
Imprévus (environ 10 %)		180 €
Total		**1 903 €**

Le budget est respecté : 1 903 € pour 2 000 € disponibles, soit une marge de 97 €. Les montants marqués « devis estimé » sont fictifs et à confirmer.

Question 6 – Méthode participative : le photolangage (2 pts)

- **Objectif** : faire exprimer les habitants sur ce que représente pour eux « bien manger au camping », leurs obstacles et leurs idées, sans passer par l'écrit.
- **Déroulement** (1 h 15, salle commune, 8 à 12 habitants) : accueil et cadre (5 min) ; chacun choisit en silence une ou deux photos parmi 40 étalées sur la table, en réponse à la question « Pour vous, qu'est-ce qui est difficile ou agréable quand vous faites vos repas ici ? » (10 min) ; tour de parole, chacun explique son choix, sans être interrompu ni jugé (30 min) ; échange libre et regroupement des idées par thèmes avec l'habitante relais (20 min) ; synthèse orale et choix des thèmes des prochains ateliers (10 min).
- **Matériel** : un jeu de photos variées (aliments, cuisine, transport, repas en famille, solitude, marché, jardin, conserves), une grande feuille, des feutres ; café et biscuits.
- **Précautions** : participation libre ; pas d'enregistrement ni de photo ; les paroles sont rapportées sans nom ; l'animateur ne commente pas les choix ; la travailleuse sociale reste disponible pour une personne qui exprime une détresse ; restitution des résultats aux participants.

On peut aussi utiliser la technique du groupe nominal pour classer les solutions proposées (vote par points), ce qui associe les habitants au choix des priorités.

Question 7 – Veille sur la précarité alimentaire et l'habitat précaire (2 pts)

- **Sources fiables** : Légifrance (Code de l'action sociale et des familles, textes sur l'aide alimentaire) ; Santé publique France et site Manger Bouger (recommandations) ; Insee et DREES (pauvreté, minima sociaux) ; rapport annuel sur l'état du mal-logement de la Fondation pour le logement des défavorisés (ancienne Fondation Abbé Pierre) ; Fédération française des banques alimentaires ; publications du conseil départemental et de la préfecture sur l'habitat permanent en camping ; revues professionnelles en santé publique et en diététique (Cairn, Santé publique).

- **Outils** : alertes par mots-clés (« précarité alimentaire », « habitat permanent camping », « aide alimentaire ») ; flux RSS des sites institutionnels ; lettre d'information du réseau des banques alimentaires ; logiciel de gestion de références (Zotero) avec fiche de lecture courte : titre, auteur, date, apport, limites.
- **Fréquence** : un temps de 30 minutes par semaine pendant le stage, puis un point mensuel tenu par la travailleuse sociale.
- **Diffusion** : une page de synthèse mensuelle datée, envoyée à l'équipe du CCAS et à l'habitante relais (version simplifiée) ; présentation orale des nouveautés lors de la réunion d'équipe. Chaque source citée est datée et vérifiée (auteur identifié, date de mise à jour, absence d'intérêt commercial).

Question 8 – Précautions éthiques (2 pts)

- **Discrétion** : les habitants craignent d'être repérés ; aucune communication publique ne nomme le camping sans leur accord ; le projet est présenté comme une offre du CCAS ouverte à tous les habitants de la commune.
- **Confidentialité des entretiens** : entretiens au domicile seulement avec l'accord du ménage, information orale sur le but, la liberté de refuser et l'usage des réponses ; aucune réponse individuelle n'est rapportée au gérant ni à d'autres habitants.
- **Données** : recueil limité au nécessaire, sans nom sur les fiches (numéro de ménage), fiches rangées sous clé au CCAS et détruites après le bilan ; traitement conforme au RGPD (information, durée de conservation, accès limité à l'équipe).
- **Pas de photos** : demande explicite des habitants (document 3) ; seuls des plats ou des mains peuvent être photographiés avec un accord écrit, et jamais les lieux identifiables.
- **Relation avec le gérant** : on l'informe de l'atelier et on lui demande l'usage de la salle, sans lui transmettre de liste de participants ni d'informations sur la situation des ménages.
- **Non-stigmatisation** : on parle de « cuisine au réchaud » et de « repas partagés », pas de « pauvreté » ; on valorise les savoir-faire et la solidarité existante ; on respecte le droit de ne pas participer (article L. 266-1 du CASF : dignité et capacité à agir).

Question 9 – Invitation et trame de l'exposé (2 pts)

Invitation écrite, en phrases courtes, affichée dans les sanitaires et la salle commune et remise de la main à la main par l'habitante relais :

> ***On cuisine ensemble au réchaud !***
>
> *Samedi 24 avril 2027, de 10 h à 12 h, dans la salle commune.*
>
> *Au menu : riz sauté aux légumes et pommes poêlées. On mange ensemble à la fin.*
>
> *C'est gratuit. Pas besoin de savoir cuisiner. Les enfants sont les bienvenus avec un adulte.*
>
> *Pour s'inscrire : parlez-en à Martine (habitante relais) ou à Claire, du CCAS, le jeudi matin.*

Message oral (habitante relais, de porte en porte) : « Samedi matin, on fait un atelier cuisine à la salle commune, avec le réchaud, comme chez nous. C'est gratuit, on mange ensemble à midi. Tu viens ? »

Trame de l'exposé (10 minutes) : 1 min, contexte, structure et demande ; 2 min, méthode du diagnostic (entretiens au domicile, 78,8 % de participation) et résultats (34,1 % de repas sautés, 53,7 % de fruits et légumes insuffisants, 22,0 % aux colis), limites (ménages non rencontrés, RR non significatif) ; 1 min 30, environnement alimentaire, arbre à problèmes et besoins selon Bradshaw ; 1 min 30, FFOM et priorités ; 2 min, objectifs, actions, calendrier et budget ; 1 min, ce que j'ai réalisé pendant le stage (photolangage, premier atelier) ; 1 min, éthique, évaluation prévue et perspectives.

Qualité de l'expression (3 pts) : phrases complètes, vocabulaire précis (prévalence, intervalle de confiance, environnement alimentaire), sources datées (Santé publique France 2019, PNNS 5 2026-2030, article L. 266-1 du CASF, Ciqual 2025), données fictives présentées comme telles.

Temps 2 – L'atelier « cuisiner au réchaud »

Question 10 – Objectifs de l'atelier (1,5 pt)

Objectif général, relié au diagnostic (70,7 % sans four, 80,5 % avec un petit réfrigérateur, 53,7 % de fruits et légumes insuffisants, 63,4 % de demande) : permettre aux habitants de préparer avec un réchaud à deux feux un repas complet, varié et économique, à partir de produits faciles à stocker.

Objectifs opérationnels, mesurés à la fin de l'atelier :

- chaque participant **réalise** au moins une étape du riz sauté ou du dessert sur un réchaud ;
- chaque participant **cite** deux produits de placard ou de congélateur qui permettent de manger des légumes sans réfrigérateur (petits pois surgelés, légumes en conserve, carottes qui se gardent au frais et au sec) ;
- au moins 7 participants sur 10 **déclarent** à l'oral, par un vote à main levée ou avec des jetons, qu'ils se sentent capables de refaire la recette chez eux.

Question 11 – Bon de commande pour 12 portions (2 pts)

Denrée	Net pour 12	Perte	Brut pour 12	Unité de commande	Coût
Riz blanc long	840 g	0 %	840 g	0,84 kg	0,84 × 1,90 = 1,60 €
Petits pois surgelés	600 g	0 %	600 g	0,6 kg	0,6 × 2,60 = 1,56 €
Carottes	720 g	15 %	720 / 0,85 = 847,1 g	0,847 kg	0,847 × 1,50 = 1,27 €
Oignons	240 g	10 %	240 / 0,9 = 266,7 g	0,267 kg	0,267 × 1,80 = 0,48 €
Œufs	12 œufs (600 g)	0 %	12 œufs	12 pièces	12 × 0,25 = 3,00 €
Dés de jambon cuit supérieur	360 g	0 %	360 g	0,36 kg	0,36 × 10,50 = 3,78 €
Huile de colza	72 g	0 %	72 g	0,072 kg	0,072 × 3,20 = 0,23 €
Sauce soja	60 g	0 %	60 g	0,06 kg	0,06 × 6,00 = 0,36 €
Pommes	1 440 g	20 %	1 440 / 0,8 = 1 800 g	1,8 kg	1,8 × 2,40 = 4,32 €
Beurre doux	48 g	0 %	48 g	0,048 kg	0,048 × 9,80 = 0,47 €
Sucre blanc	48 g	0 %	48 g	0,048 kg	0,048 × 1,20 = 0,06 €
Fromage blanc 2-3 % MG	960 g	0 %	960 g	0,96 kg	0,96 × 2,90 = 2,78 €
Cannelle, poivre	–	–	–	forfait	0,30 €
Total					**20,21 €**

Coût par portion : 20,21 / 12 = **1,68 €** (1,684 €), inférieur au budget de 1,80 € : le budget est respecté, avec une marge de 0,12 € par portion (environ 1,40 € pour l'atelier), qui couvre la sauce soja sans gluten de Madame V. Le jambon (3,78 €) et les pommes (4,32 €) sont les postes les plus coûteux.

Question 12 – Fiche technique adaptée au matériel et adaptations individuelles (3 pts)

Fiche technique – Riz sauté aux petits pois, carottes, œuf et jambon ; pommes poêlées à la cannelle et fromage blanc (12 portions, deux réchauds de deux feux, sans four ni réfrigérateur)

Ingrédients : riz 840 g ; petits pois surgelés 600 g ; carottes 847 g brutes ; oignons 267 g bruts ; 12 œufs ; dés de jambon 360 g ; huile de colza 72 g ; sauce soja 60 g ; poivre ; pommes 1,8 kg brutes ; beurre 48 g ; sucre 48 g ; cannelle 4 g ; fromage blanc 960 g.

Matériel : 2 faitouts, 2 grandes poêles ou sauteuses, 1 petite poêle et 1 petite casserole réservées aux portions sans gluten, passoire, saladiers, planches et couteaux comptés, épluchoirs, râpe, balance, verre doseur, thermomètre, 2 glacières avec pains de glace, bidons d'eau potable, coupes et assiettes, boîtes fermées.

Étapes : 1. Vérifier la température des glacières (au plus 4 °C) ; se laver les mains. 2. Feu 1 et feu 2 : cuire le riz

dans deux faitouts d'eau bouillante (environ 12 minutes) ; égoutter, étaler dans un plat pour que la vapeur s'échappe. 3. Pendant ce temps, éplucher et tailler les carottes en petits dés, ciseler les oignons. 4. Feu 3 et feu 4 : faire revenir oignons et carottes dans la moitié de l'huile 8 minutes, ajouter les petits pois encore surgelés 5 minutes. 5. Battre les œufs (cassés un par un dans un bol) et les cuire en omelette fine bien prise dans la poêle libérée par le riz, puis les couper en lanières. 6. Mélanger dans les deux sauteuses le riz, les légumes, le jambon et l'omelette ; sauter 3 minutes avec le reste de l'huile ; ajouter la sauce soja hors du feu ; poivrer. Servir aussitôt. 7. Sur les feux libérés : poêler les pommes en dés avec le beurre, le sucre et la cannelle 10 minutes. 8. Servir les pommes tièdes sur le fromage blanc sorti de la glacière au dernier moment.

Points critiques : riz cuit **le jour même et consommé dans l'heure** (pas de riz de la veille, puisqu'il n'y a pas de réfrigérateur) ; œufs cuits jusqu'à être bien pris ; jambon, œufs, beurre et fromage blanc gardés en glacière jusqu'à l'utilisation ; portion sans gluten préparée en premier, avec du matériel réservé ; sauce soja ajoutée à la fin et à part pour Monsieur H.

Organisation des feux : pendant la cuisson du riz (deux feux), les deux autres feux servent aux légumes puis à l'omelette ; les pommes cuisent pendant que les participants mangent le plat. On réduit ainsi le temps sans augmenter le matériel.

Adaptations individuelles :

- **Monsieur H. (hypertension)** : sa portion est servie **sans sauce soja** (la sauce soja apporte 40,4 % du sel du repas, voir question 13) ; il assaisonne avec du poivre, de la ciboulette ou du jus de citron. On lui montre que les dés de jambon apportent aussi du sel (0,55 g par portion) et qu'on peut en réduire la quantité chez lui. Son repas passe de 1,62 g à 0,97 g de sel.
- **Madame V. (maladie cœliaque)** : la sauce soja classique contient du blé, donc du **gluten** : on utilise une sauce soja portant la mention « sans gluten » (ou on n'en met pas). On vérifie l'étiquette des dés de jambon. Sa portion est cuite **en premier**, dans la petite poêle réservée, avec des ustensiles propres, et servie à part pour éviter toute contamination croisée. Le riz, les légumes, les œufs, les pommes et le fromage blanc nature sont naturellement sans gluten.
- **Monsieur N. (sans porc)** : sa part est préparée sans jambon, avant l'ajout du jambon dans la sauteuse, avec un œuf supplémentaire. Son repas apporte alors 678,0 kcal, 27,86 g de protéines et 1,23 g de sel (calcul : 642,53 − 34,5 + 70 kcal ; 27,55 − 6,09 + 6,4 g de protéines).
- **Madame J. (mastication difficile)** : riz cuit un peu plus longtemps, carottes en très petits dés ou râpées et bien cuites, petits pois écrasés à la fourchette si elle le souhaite ; pommes cuites jusqu'à être fondantes (texture de compote) ; fromage blanc lisse. On lui propose de manger à son rythme. On l'encourage, en privé, à faire contrôler sa prothèse par son dentiste.
- **Enfant de 9 ans** : il participe avec sa mère à des tâches sans danger (laver les légumes, écosser, mélanger les œufs, peser le riz), loin des réchauds ; il utilise un couteau à bout rond pour les pommes. Sa portion est un peu plus petite ; on lui propose de goûter sans l'obliger.

Question 13 – Apports d'une portion et sel de la sauce soja (2,5 pts)

Apport par portion	Riz sauté	Pommes poêlées et fromage blanc	Repas complet
Énergie	470,37 kcal	172,17 kcal	**642,53 kcal**
Protéines	21,38 g	6,16 g	27,55 g
Glucides	63,50 g	21,11 g	84,61 g
dont sucres	5,90 g	19,83 g	25,73 g
Lipides	12,89 g	6,21 g	19,10 g
Fibres	6,52 g	1,85 g	8,37 g
Sel	1,54 g	0,08 g	1,62 g
Calcium	86,88 mg	115,15 mg	202,02 mg
Fer	3,34 mg	0,15 mg	3,49 mg
Vitamine C	12,15 mg	5,53 mg	17,68 mg

Calcul posé – Exemples de calcul, répartition de l'énergie et sel de la sauce soja

Riz : 70 g × 350 / 100 = 245 kcal. Fromage blanc : 80 g × 131 / 100 = 104,8 mg de calcium. Jambon : 30 g × 1,82 / 100 = 0,55 g de sel.

Répartition de l'énergie : protéines 27,55 × 4 = 110,2 kcal, soit **17,1 %** ; lipides 19,10 × 9 = 171,9 kcal, soit **26,8 %** ; glucides 84,61 × 4 = 338,4 kcal, soit **52,7 %** ; fibres environ 2,6 %.

Sel de la sauce soja : 5 g × 13,1 / 100 = **0,655 g**, soit 0,655 / 1,62 = **40,4 %** du sel du repas (hors sel ajouté). Le jambon en apporte 33,7 %.

Sucres ajoutés : 4 g × 3,99 = 15,96 kcal, soit 2,5 % de l'énergie du repas.

Commentaire : le repas est complet et économique ; la répartition de l'énergie est équilibrée, avec un bon apport de protéines (œuf, jambon, fromage blanc, petits pois). Les légumes (130 g de petits pois, carottes et oignon) et la pomme (120 g) représentent environ trois portions de fruits et légumes, dont des surgelés faciles à stocker. Les fibres (8,37 g) sont correctes ; on peut les augmenter avec un riz complet ou des légumes secs. Le calcium (202,02 mg, soit 21,3 % des 950 mg conseillés à l'adulte de 25 ans et plus) et la vitamine C (17,68 mg, soit 16,1 % des 110 mg) sont modestes : la cuisson et l'absence de crudités en limitent l'apport ; on conseille d'ajouter un produit laitier et un fruit cru dans la journée. Les sucres ajoutés restent faibles (2,5 % de l'énergie). **Pour Monsieur H.**, la sauce soja est la première source de sel du repas : sans elle, le repas apporte 0,97 g de sel au lieu de 1,62 g. Une seule cuillère à café de sauce soja (5 g) apporte autant de sel qu'environ 36 g de jambon cuit : c'est un « sel caché » à repérer sur les étiquettes.

Question 14 – Comparaison avec une conserve et trois recettes « au réchaud » (2 pts)

Une portion du riz sauté pèse environ 400 g une fois cuite (le riz cru triple à peu près de poids à la cuisson). Le plat cuisiné en conserve coûte 2,40 € les 300 g, soit **3,20 €** pour 400 g. Le riz sauté seul coûte 12,28 / 12 = **1,02 €** la portion (hors forfait) : il est environ trois fois moins cher pour une quantité équivalente, et le repas complet avec le dessert ne coûte que 1,68 €. Il contient aussi plus de légumes et permet de choisir le sel. La conserve garde des avantages réels pour ce public (se garde sans réfrigérateur, prête en 5 minutes, utile en réserve l'hiver) : on ne la condamne pas, on propose de l'**enrichir** (ajouter des petits pois surgelés ou des légumes en conserve rincés) et de la réserver aux jours difficiles.

Trois recettes « au réchaud » à partir d'un placard et d'un petit congélateur :

- **Pâtes aux lentilles et à la tomate** : pâtes, lentilles en conserve rincées, tomates concassées en conserve, oignon, herbes ; une casserole, 15 minutes ; apporte des légumes secs (repère « au moins deux fois par semaine »).
- **Semoule aux pois chiches et légumes** : semoule, pois chiches en conserve, carottes, courgettes ou légumes surgelés, épices ; une casserole et un saladier, 15 minutes.
- **Omelette aux légumes surgelés et pommes de terre** : œufs, poêlée de légumes surgelés, pommes de terre (qui se gardent au frais et au sec) ; une poêle, 20 minutes.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 15 – Déroulé minuté des 3 heures (2 pts)

Horaire	Candidat	Habitants
9 h 00 – 9 h 30	Installe la salle ; vérifie les réchauds, les flexibles et l'aération ; contrôle la température des glacières ; pèse les denrées par poste.	–
9 h 30 – 10 h 00	Prépare 4 postes (légumes ; riz ; œufs et omelette ; dessert) et le poste sans gluten ; met l'eau à chauffer pour le riz à 9 h 50.	–
10 h 00 – 10 h 15	Accueil avec l'habitante relais, café, cadre, présentation du menu.	S'installent, choisissent un poste.

Horaire	Candidat	Habitants
10 h 15 – 10 h 40	Montre les gestes clés ; lance la cuisson du riz (feux 1 et 2) ; prépare en premier la portion sans gluten.	Épluchent et taillent les légumes, cassent les œufs, épluchent les pommes.
10 h 40 – 11 h 05	Guide les binômes ; contrôle la cuisson des œufs ; anime l'échange « Qu'est-ce que vous cuisinez avec deux feux ? ».	Font revenir légumes et omelette (feux 3 et 4) ; égouttent le riz ; assemblent le riz sauté.
11 h 05 – 11 h 15	Sert le plat ; met les pommes à cuire sur les feux libérés.	Dressent les assiettes.
11 h 15 – 11 h 45	Anime la dégustation et le partage de recettes ; sert le dessert.	Mangent ensemble ; partagent leurs astuces.
11 h 45 – 12 h 00	Évaluation orale ; présentation du prochain atelier ; remise de la fiche recette illustrée.	Votent avec des jetons ; proposent des thèmes.
12 h 00 – 12 h 30	Remise en état, vaisselle, tri des déchets, élimination du riz restant non consommé dans l'heure ; bilan avec l'habitante relais et la travailleuse sociale.	Volontaires pour aider s'ils le souhaitent.

Question 16 – Méthodes d'animation, habitante relais et grille de dégustation (1,5 pt)

- **Valoriser les savoir-faire** : on commence par demander ce que chacun cuisine avec deux feux ; un habitant qui sait faire montre son geste au groupe ; les astuces sont recueillies pour le livret de recettes.
- **Binômes et entraide** : les plus à l'aise avec les moins à l'aise ; l'enfant avec sa mère.
- **Rôle de l'habitante relais** : elle invite les voisins, accueille, fait le lien et rassure ; elle co-anime un poste ; elle recueille ensuite les retours de ceux qui n'osent pas parler au candidat. Elle n'est pas chargée de surveiller ni de rapporter ce qui se dit.
- **Supports sans écrit obligatoire** : fiche recette en photos et pictogrammes, quantités en verres et en cuillères.
- **Grille de dégustation adaptée** : trois bols posés sur la table (« J'aime », « Moyen », « Je n'aime pas ») ; chaque participant dépose un jeton pour le plat et un pour le dessert. Le décompte se fait devant tout le monde, ce qui rend le résultat visible et ludique.

Question 17 – Hygiène sans réfrigérateur, sécurité au gaz et éco-gestes (1,5 pt)

- **Glacières** : deux glacières propres, pains de glace congelés la veille, thermomètre à l'intérieur ; température vérifiée à l'arrivée et toutes les 30 minutes (au plus 4 °C) ; ouverture la plus courte possible ; denrées sorties au dernier moment.
- **Riz et Bacillus cereus** : les spores résistent à la cuisson (document 4) ; le riz est cuit le jour même, utilisé aussitôt et consommé dans l'heure ; sans réfrigérateur, aucun reste de riz n'est conservé ni distribué ; les quantités sont calculées au plus juste.
- **Œufs** : gardés en glacière ; cassés un par un dans un bol ; coquilles jetées aussitôt ; mains lavées après ; omelette cuite jusqu'à être bien prise.
- **Restes** : pas de restes emportés, sauf les pommes cuites, qui peuvent être emportées dans une boîte fermée et rangées au réfrigérateur du domicile dans l'heure ; on donne cette consigne à l'oral.
- **Eau** : eau potable en bidons pour le lavage des légumes et la cuisson ; lavage des mains avec savon et essuie-mains à usage unique.
- **Sécurité au gaz** : réchauds posés sur une surface stable et non inflammable ; flexibles en bon état et dans leur date de validité ; salle aérée ; bouteilles fermées après usage ; feux jamais laissés sans surveillance ; manches tournés vers l'intérieur ; enfant tenu à distance des feux ; couverture anti-feu à portée de main.
- **Trois éco-gestes** : pommes lavées et coupées avec la peau quand c'est possible ; épluchures portées au composteur du jardin partagé ; vaisselle réutilisable plutôt que des assiettes jetables ; feu coupé dès la fin de la cuisson et couvercle sur les faitouts pour économiser le gaz.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 18 – Réalisation (3 pts)

Le jury observe : l'organisation des quatre feux et le respect du temps ; la maîtrise de la cuisson du riz (grains cuits, non collants) et de l'omelette bien prise ; le contrôle des glacières ; la portion sans gluten préparée à part ; la conduite des binômes sans faire à la place des habitants ; le dressage d'une assiette (riz sauté coloré, lanières d'omelette visibles) et d'une coupe de dessert (fromage blanc, pommes tièdes à la cannelle) ; la remise en état.

Question 19 – Évaluation sans écrit obligatoire et suite du projet (1 pt)

- **Évaluation** : vote avec des jetons sur trois questions (« J'ai aimé », « Je peux refaire la recette chez moi », « Je reviendrai au prochain atelier ») ; tour de table oral (« Une chose que je retiens ») ; nombre de participants comparé à l'objectif ; observation par l'habitante relais des recettes refaites dans les semaines suivantes. La fiche de présence ne mentionne que le prénom ou un numéro et elle est détruite après le bilan.
- **Suite du projet** : restitution des résultats aux habitants ; ateliers suivants choisis avec eux (placard d'hiver, légumes secs, légumes du jardin partagé) ; livret de recettes au réchaud construit à partir de leurs astuces ; transport solidaire vers les colis ; second recueil par entretiens en mars 2028 pour mesurer l'évolution des indicateurs.

Barème – Barème

Temps 1 : participation et indicateurs 2 ; risque relatif 1,5 ; environnement alimentaire, arbre à problèmes et Bradshaw 2 ; FFOM, priorités et problématique 1,5 ; objectifs, actions, calendrier et budget 2 ; méthode participative 2 ; veille 2 ; éthique 2 ; invitation et exposé 2 ; expression 3 ; total 20 points. Temps 2 : objectifs 1,5 ; bon de commande 2 ; fiche technique et adaptations 3 ; apports et sel 2,5 ; comparaison et recettes 2 ; déroulé 2 ; animation 1,5 ; hygiène et sécurité 1,5 ; réalisation 3 ; évaluation et suite 1 ; total 20 points.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages sur les 52 ménages au lieu des 41 rencontrés ; conclure à un effet de l'âge alors que l'intervalle de confiance du risque relatif contient 1 ; expliquer les difficultés par le seul « manque de motivation » des habitants ; oublier que les ménages non rencontrés sont peut-être les plus en difficulté ; dépasser le budget de 2 000 € ou oublier les imprévus ; proposer une recette qui demande un four ou un réfrigérateur ; cuire le riz la veille ; oublier que la sauce soja contient du gluten et beaucoup de sel ; prendre des photos ou citer des noms d'habitants ; exiger une évaluation écrite.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Ce que je sais faire	Sujet	Acquis	En cours	À retravailler
C3.1	Calculer un taux de participation et des prévalences ; redresser une prévalence selon la composition d'une population	S1, S3			
C3.1	Repérer les biais d'un recueil (recrutement, non-réponse, ménages non rencontrés) et leur effet sur les résultats	S1, S3			
C3.1	Analyser l'environnement alimentaire et construire un arbre à problèmes ; classer les besoins selon Bradshaw	S1, S3			
C3.1	Hiérarchiser des problèmes avec la méthode de Hanlon et le test PEARL, ou avec des critères explicites	S1, S3			
C3.1	Formuler des objectifs SMART reliés au diagnostic ; construire un calendrier et un budget exacts	S1, S3			
C3.2	Établir un bon de commande avec quantités brutes et nettes et vérifier un budget	S2, S3			
C3.2	Calculer des apports avec la table Ciqual 2025, la répartition de l'énergie et la part d'une source de sel	S2, S3			
C3.2	Adapter une recette au matériel disponible (une poêle, deux réchauds, sans four ni réfrigérateur) et à des besoins individuels	S2, S3			
C3.2	Appliquer l'hygiène des œufs, du riz cuit (*Bacillus cereus*), des glacières et des plats emportés	S2, S3			
C3.2	Poser un cadre bienveillant et réagir à une émotion ou à une question hors de son champ	S2, S3			
C3.3	Calculer un risque relatif et son intervalle de confiance ; interpréter un résultat non significatif	S1, S3			
C3.3	Calculer un intervalle de confiance d'une proportion et une taille d'échantillon corrigée	S1			
C3.3	Choisir et conduire une méthode participative (groupe nominal, photolangage)	S1, S3			
C3.4	Organiser une veille datée sur la santé au travail, la précarité alimentaire et l'habitat précaire	S1, S3			
C3.5	Rédiger une invitation claire et une trame d'exposé de 10 minutes	S1, S3			
C3.6	Respecter la confidentialité, le droit à l'image et la discrétion d'un public qui craint d'être repéré	S1, S2, S3			

Modèles officiels utilisés : structure des sujets U62 (2002-2014) et E5.B (2021-2024) pour le bon de commande, la fiche technique et l'organisation ; séquence du guide d'accompagnement 2025 (femmes bénéficiaires de colis disposant d'une seule plaque) pour l'adaptation au matériel et au budget ; BTS blanc CNED E5B pour le calcul

nutritionnel ; texte de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024) pour la répartition des compétences entre les deux temps.

DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE

CHAPITRE 8

Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage

Mots-clés : Démarche de projet (2), Stratégies, Partenaires, Financements, Calendrier, Budget, Pilotage

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 8 · Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage · version normale

1 COURS

Mise en page normale · 94 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 97

2 FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 6 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 98 à 103

3 CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 118 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 104 à 221

4 ANNALES E5

Mise en page normale · 38 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 222 à 259

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 • Cours **4**

8.1 Compétences mobilisées 6
8.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6
8.3 Cours 8
8.4 Approfondissements 74
8.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 80
8.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 81
8.7 L'essentiel à retenir 85
8.8 Entraînement 86
8.9 Glossaire 96
8.10 Renvois bibliographiques par notion 97
8.12 Bibliographie numérotée 97

2 • Fiche de révision et fiches-outils **98**

Fiche de révision du chapitre 8 100
1. Les définitions à savoir 100
2. Les outils 100
3. Les formules 101
4. Les financeurs 101
5. Les pièges 101
6. Auto-test 101
7. Flashcards 101
Compléments du chapitre enrichi 102
Fiches-outils du chapitre 8 102
O8.1 – Fiche action QQOQCCP 102
O8.2 – Cartographie des parties prenantes 103
O8.3 – Matrice RACI 103
O8.4 – Analyse d'un cahier des charges 103
O8.5 – Calcul PERT 103
O8.6 – Suivi budgétaire prévu / réalisé 103
O8.7 – Registre des risques 103
O8.8 – Compte rendu de réunion 103

3 • Cahier d'exercices **104**

Cahier d'exercices – Chapitre 8 107
Partie 1 – Les stratégies, les actions et la fiche action 109
Partie 2 – Les parties prenantes, le partenariat et le pilotage 125
Partie 3 – Les financements et les appels à projets 139
Partie 4 – Planifier le projet 153
Partie 5 – Construire et suivre le budget 166
Partie 6 – La trésorerie, la logistique et les méthodes pédagogiques 178
Partie 7 – Piloter : tableau de bord, risques et communication 190
Partie 8 – Synthèse : du plan d'action au cas complet 204
Bilan : grille d'auto-évaluation 221

4 • Annales E5 ..... **222**

Cahier d'annales E5 – chapitre 8 224
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 226
Partie II – Les corrigés détaillés 239
Grille d'auto-évaluation 259

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS

CHAPITRE

08

Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage

Démarche de projet (2) | Stratégies | Partenaires | Financements | Calendrier

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

8.1 Compétences mobilisées ... 6

8.2 Croisement référentiel × précisions × indications ... 6

8.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 ... 7

8.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED ... 7

8.3 Cours ... 8

8.3.1 Choisir les stratégies et les actions ... 8

8.3.2 Les parties prenantes et le partenariat ... 13

8.3.3 Les financements et les appels à projets ... 18

8.3.4 Planifier le projet ... 25

8.3.5 Construire et suivre le budget ... 31

8.3.6 Piloter le projet ... 38

8.3.7 Élaborer le plan de communication du projet ... 43

8.3.8 Choisir les méthodes et les outils pédagogiques ... 48

8.3.9 Organiser la logistique des ateliers ... 55

8.3.10 Anticiper la trésorerie du projet ... 60

8.3.11 Rédiger un dossier de demande de financement : exemple commenté ... 63

8.3.12 La convention de partenariat : un modèle commenté ... 64

8.3.13 Estimer la charge de travail et tenir une feuille de temps ... 67

8.3.14 Utiliser les outils numériques du projet ... 68

8.3.15 Fil rouge : le plan d'action d'Inès ... 73

8.4 Approfondissements ... 74

8.4.1 Le cadre logique, outil des financeurs ... 74

8.4.2 Le travail en réseau et la coordination territoriale ... 76

8.4.3 La pérennisation dès la conception ... 77

8.4.4 Les contrats pluriannuels et les fonds européens ... 78

8.4.5 La gestion des bénévoles ... 79

8.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 ... 80

8.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles ... 81

Ce que le jury attend sur la conception et le pilotage ... 84

8.7 L'essentiel à retenir ... 85

8.8 Entraînement ... 86

8.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) ... 86

8.8.2 Exercices ... 87

8.8.3 Questions de réflexion ... 90

8.8.4 Étude de cas ... 91

8.8.5 Mises en situation express ... 92

8.8.6 Exercices complémentaires ... 94

8.9 Glossaire ... 96

8.10 Renvois bibliographiques par notion ... 97

8.12 Bibliographie numérotée ... 97

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- choisir des stratégies et des actions cohérentes avec les objectifs, en combinant éducation, action sur l'environnement et participation ;
- décrire une action avec la méthode QQOQCCP et la formaliser dans une fiche projet ;
- identifier et analyser les parties prenantes (cartographie, matrice pouvoir/intérêt, matrice RACI) et construire un partenariat (convention, comité de pilotage) ;
- connaître les principaux financeurs (ARS et fonds d'intervention régional, collectivités, CAF, conférence des financeurs, fondations, mutuelles) et répondre à un appel à projets ;
- planifier un projet (diagramme de Gantt, réseau PERT, chemin critique, jalons) ;
- construire un budget prévisionnel équilibré, calculer des coûts et des ratios, suivre le budget réalisé ;
- piloter un projet : tableau de bord, gestion des risques, analyse des écarts, ajustements, comptes rendus.

8.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.1	Cœur de la compétence : concevoir un plan d'action et des moyens réalistes, mobiliser partenaires et financements, piloter	Plan d'action et moyens de mise en œuvre réalistes ; projet mis en œuvre ; ajustements envisagés
C3.2	Programmer et organiser les ateliers dans le plan d'action (calendrier, budget des denrées, logistique)	Programme d'ateliers adapté ; organisation cohérente
C3.5	Présenter le projet aux partenaires et financeurs, animer une réunion, travailler en équipe	Expression écrite et orale maîtrisée ; techniques d'animation et posture adaptées
C3.6	Partager les documents du projet (tableau de bord, budget) de façon sécurisée	Environnement numérique géré et sécurisé ; bonnes pratiques de messagerie

8.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Stratégies d'intervention	Choisir et justifier des actions	Données probantes ; combinaison de stratégies
Plan d'action	Formaliser une action (QQOQCCP, fiche projet)	Fiche F4
Parties prenantes, partenariat	Identifier, analyser, mobiliser	Matrice pouvoir/intérêt ; convention ; COPIL
Financements, appels à projets	Repérer les financeurs ; lire un cahier des charges ; rédiger une réponse	FIR, CAF, collectivités ; formulaire Cerfa n° 12156
Planification	Construire un Gantt ; identifier le chemin critique	Fiche F5
Budget	Construire un budget équilibré ; calculer coûts et ratios	Plan comptable associatif simplifié ; fiche F6 ; tableur
Pilotage	Suivre, anticiper les risques, ajuster	Tableau de bord ; matrice des risques

8.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : bloc 3, compétence C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition », indicateurs « Plan d'action et moyens de mise en œuvre réalistes » et « Projet mis en œuvre ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 63 pour les notions et les outils de la démarche de projet, p. 108 pour les étapes et l'apport des autres blocs). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 8.2.2.

Texte	Critère ou notion	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 63	Étapes : conception du projet et plan d'action ; conduite et pilotage du projet	8.3.1 ; 8.3.4 à 8.3.6 ; 8.3.15 (fil rouge)
Guide 2025, p. 63	Appel à projets ; parties prenantes	8.3.2 et 8.3.3 ; 8.3.11 (dossier commenté) ; 8.3.12 (convention)
Guide 2025, p. 63	Cahier des charges ; fiche projet ; conducteur de séance	8.3.3 ; 8.3.1 (fiche projet) ; encadré « Repères » du CNED en 8.3.2 ; chapitre 10
Guide 2025, p. 63	Plan de communication	8.3.7
Guide 2025, p. 63	Diagramme de Gantt, feuille de temps, tableaux de bord	8.3.4 ; 8.3.13 ; 8.3.6
Guide 2025, p. 63	Logiciels de gestion de projet, mind-mapping, tableur, formulaire en ligne	8.3.14
Guide 2025, p. 63	Budgets (autres enseignements)	8.3.5 ; 8.3.10 (trésorerie)
Référentiel, C3.1	« Plan d'action et moyens de mise en œuvre réalistes » ; « Projet mis en œuvre »	8.3.1 à 8.3.6 ; 8.3.9 (logistique)

8.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le fascicule du CNED *Environnement professionnel – Les essentiels* (2e année) présente les étapes du projet et ses parties prenantes (séquence 2) et les acteurs des politiques de santé (séquence 3). Il ne détaille pas la planification ni le budget, qui viennent du guide de 2025. Le tableau relie chaque passage à ce cours.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Essentiels S2 §2 (p. 10 et 11)	Parties prenantes : équipe, partenaires, usagers ; étapes du diagnostic à l'évaluation (doc. 3)	8.3.2 (parties prenantes, encadré « Repères » du CNED) ; 8.3.1
Essentiels S2 §2 (p. 12)	Communication et valorisation tout au long du projet ; cadre à respecter	8.3.7 (plan de communication) ; 8.3.12 (convention) ; chapitre 6
Essentiels S3 §1.1 (p. 13)	Quatre types d'acteurs : consultatifs, décideurs, opérateurs, financeurs	8.3.2 (encadré « Repères » du CNED) ; 8.3.3 (financeurs)
Essentiels S3 §1.2 (p. 14)	Priorité sanitaire, programme, planification	8.3.1 (choisir des actions cohérentes avec les politiques) ; chapitre 7

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été corrigé

- **Instances** (p. 14 et 15) : le fascicule écrit « CRAS », « Haut Comité de santé publique » et « CNSP ». Il faut lire **CRSA** (conférence régionale de la santé et de l'autonomie), **Haut Conseil** de la santé publique (depuis 2004) et **CNS** (Conférence nationale de santé).
- **Politiques de référence** : un projet de 2026 s'appuie sur le **PNNS 5** et le **PNA 4** (2026-2030, lancés le 8 avril 2026) et sur la SNANC 2025-2030, et non sur le PNNS 4 (2019-2023) ; les annales du chapitre ont été corrigées.

- **Financements vérifiés en octobre 2026** : le formulaire de demande de subvention reste le Cerfa n° 12156*06 (compte rendu : Cerfa n° 15059) ; le programme « Mieux manger pour tous » a publié ses appels à projets 2026 ; le FSE+ couvre la période 2021-2027.

8.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Appels à projets** : les ARS (fonds d'intervention régional), les DRAAF (programme national pour l'alimentation, PNA 4 2026-2030) et les services de l'État chargés de la cohésion sociale (« Mieux manger pour tous ») publient leurs appels à projets chaque année, avec des priorités et des calendriers propres : consultez leurs sites en début d'année.
- **Demandes de subvention** : le formulaire Cerfa n° 12156*06 et le service en ligne « Le Compte Asso » sont les outils de référence pour les associations (version en vigueur en octobre 2026 ; compte rendu financier : Cerfa n° 15059).
- **Interventions probantes** : le répertoire de Santé publique France des interventions efficaces ou prometteuses est enrichi régulièrement : consultez-le avant de choisir une action.
- **Outils numériques** : avant d'utiliser un logiciel de gestion de projet ou un formulaire en ligne pour des données personnelles, vérifiez les recommandations de la CNIL et la politique de votre structure (voir la partie « Utiliser les outils numériques du projet » de ce cours).

8.3.1 Choisir les stratégies et les actions

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S2 §2 (p. 10 et 11) ; Essentiels M1 S3 §1.2 (p. 14)

Combiner plusieurs stratégies

Les objectifs spécifiques (chapitre 7) indiquent **ce qui doit changer** ; les stratégies indiquent **par quels leviers**. Les interventions les plus efficaces en nutrition **combinent** plusieurs leviers (Charte d'Ottawa, chapitre 1) : une action purement informative change peu les comportements, surtout chez les publics défavorisés.

Stratégie	Exemples en nutrition	Facteurs visés (PRECEDE)
Éducation pour la santé	Ateliers culinaires, dégustations, groupes de parole, éducation sensorielle	Prédisposants (connaissances, attitudes) et facilitants (compétences)
Action sur l'environnement	Eau en carafe, fruits à la récréation, menus améliorés, partenariat avec l'épicerie solidaire, jardin partagé	Facilitants (accessibilité, prix, offre)
Renforcement du lien social et de l'entourage	Mamans relais, repas partagés, implication des familles	De renforcement
Participation et développement du pouvoir d'agir	Comité d'usagers, choix des recettes par les familles, habitants enquêteurs	Tous ; empowerment
Plaidoyer	Note au CLS sur l'offre alimentaire du quartier, demande de navette vers le marché	Environnement, politiques
Formation des relais	Formation des animateurs périscolaires, des aides à domicile	Facilitants ; démultiplication

Méthode pas à pas – Choisir une action : 6 questions

1. **Cohérence** : l'action répond-elle à un objectif spécifique (et à une cause de l'arbre) ?
2. **Efficacité** : existe-t-il des preuves ou des retours d'expérience (portail des interventions probantes de Santé publique France, littérature, évaluations d'actions similaires) ?
3. **Adaptation** au public : littératie, langue, culture, horaires, budget, mobilité (chapitres 4 et 5) ?
4. **Faisabilité** : compétences, locaux, matériel, temps, budget ?
5. **Acceptabilité** et participation : les personnes ont-elles été consultées ?
6. **Éthique** : non-stigmatisation, équité, indépendance (chapitre 6) ?

Décrire une action : la méthode QQOQCCP

Question	Ce qu'on précise	Exemple : atelier n° 3 du projet des Tilleuls
Quoi ?	Nature de l'action, contenu	Atelier culinaire « Repas complet petit budget »
Qui ?	Public ; animateurs ; partenaires	12 familles ; Inès et la diététicienne ; l'épicerie fournit les légumes secs
Où ?	Lieu, accessibilité	Cuisine pédagogique du centre social, rez-de-chaussée
Quand ?	Date, horaire, durée, fréquence	Mardi 28 mars 2028, 9 h – 12 h
Comment ?	Méthodes, outils, déroulé	Photo-expression, réalisation en 3 groupes, dégustation, calcul du coût (conducteur F7)
Combien ?	Moyens humains, matériels, coût	2 animatrices ; 16,55 € de denrées ; 6 h de préparation
Pourquoi ?	Objectif visé	Objectif spécifique 1 (légumes secs) et 2 (connaissances petit budget)

Définition – Fiche projet

Document de synthèse (1 à 2 pages) qui présente le projet à un partenaire, à un financeur ou à un jury : intitulé, porteur, contexte et constats, public, objectifs, actions, partenaires, calendrier, évaluation, budget (fiche **F4**). Elle sert de base à la réponse aux appels à projets.

De l'arbre à problèmes au plan d'action : la chaîne logique

Un plan d'action solide ne commence pas par une liste d'idées d'ateliers. Il commence par les **causes** retenues dans l'arbre à problèmes (chapitre 7). Chaque cause sur laquelle le projet veut agir devient un **objectif spécifique** ; chaque objectif spécifique appelle une ou plusieurs **stratégies** ; chaque stratégie se traduit en **actions** concrètes, et chaque action reçoit un **indicateur** de suivi. Cette chaîne garantit que rien n'est fait « pour faire » et que rien d'important n'est oublié.

Cause retenue (arbre à problèmes)	Objectif spécifique	Stratégie	Action	Indicateur de suivi
Les parents ne savent pas cuisiner les légumes secs	Augmenter la part des familles qui cuisinent des légumes secs chaque semaine	Éducation pour la santé	Quatre ateliers « légumes secs en 30 minutes »	Nombre d'ateliers réalisés ; taux de présence
Le seul commerce proche vend peu de produits frais, à prix élevé	Améliorer l'accès aux fruits et aux légumes frais	Action sur l'environnement	Marché de producteurs mensuel sur la place ; panier à prix solidaire	Nombre de marchés ; nombre de paniers vendus

Cause retenue (arbre à problèmes)	Objectif spécifique	Stratégie	Action	Indicateur de suivi
Les parents se sentent seuls face aux refus des enfants	Renforcer le soutien entre parents	Lien social	Groupe de parole mensuel avec la PMI	Nombre de séances ; nombre de parents présents
Les familles ne sont jamais consultées sur les actions du quartier	Associer les familles aux choix du projet	Participation	Comité de quatre parents au comité de pilotage	Nombre de réunions avec les parents ; décisions prises sur leur proposition

Le tableau se lit dans les deux sens. De gauche à droite, il répond à la question **« comment ? »** : comment agir sur cette cause ? De droite à gauche, il répond à la question **« pourquoi ? »** : pourquoi faire cette action ? Si une action ne peut pas être reliée à une cause, elle est « orpheline » : on la supprime ou on la rattache à un objectif. Si une cause importante n'a aucune action, le projet a un angle mort.

Méthode pas à pas – Construire la chaîne logique en cinq étapes

1. Reprendre l'arbre à problèmes validé et entourer les causes sur lesquelles le projet peut agir (critères de faisabilité et de priorité, chapitre 7).

2. Transformer chaque cause en objectif spécifique SMART : la cause négative devient un changement positif mesurable.

3. Choisir une ou deux stratégies par objectif, en veillant à combiner, sur l'ensemble du projet, des stratégies individuelles (éducation) et collectives (environnement, lien social, plaidoyer).

4. Décrire chaque action avec la méthode QQOQCCP (8.3.1) et vérifier sa faisabilité.

5. Associer un indicateur de suivi à chaque action ; les indicateurs de résultat, liés aux objectifs, sont préparés pour l'évaluation (chapitre 9).

Attention – Une action peut servir plusieurs objectifs

Un atelier culinaire peut à la fois donner un savoir-faire (objectif 1) et créer du lien entre parents (objectif 3). C'est un avantage, à condition de le prévoir : on choisit alors des méthodes qui servent les deux objectifs (travail en binômes, repas pris ensemble) et on suit les deux indicateurs. À l'inverse, un projet dont toutes les actions sont des ateliers n'agit que sur les facteurs individuels, même s'il en organise beaucoup.

Exemple – Une chaîne logique incomplète, repérée en comité technique

Dans un projet sur l'alimentation de personnes âgées vivant seules (CCAS fictif), l'arbre retenait trois causes : la difficulté à faire les courses sans voiture, la perte d'envie de cuisiner pour soi seul, et la méconnaissance des besoins en protéines après 70 ans. Le plan proposait cinq conférences et une distribution de livrets. Le comité technique a constaté que la première cause n'avait aucune action, et que la deuxième était traitée par une information alors qu'elle relève du lien social. Le plan a été complété par une navette solidaire vers le marché (environnement) et par des repas partagés mensuels (lien social) ; deux conférences sur cinq ont été remplacées par des ateliers.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.1

Dans une école de production (structure fictive qui forme des jeunes de 15 à 18 ans en atelier), l'arbre à problèmes retient trois causes du saut du petit-déjeuner : les horaires de transport très matinaux, l'absence de produits du petit-déjeuner dans les placards en fin de mois, et l'idée qu'un petit-déjeuner « prend trop de temps ». Pour chaque cause, proposez un objectif spécifique, une stratégie, une action et un indicateur de suivi.

Corrigé

Exemple de réponse. Horaires matinaux : augmenter la part de jeunes qui prennent un petit-déjeuner avant de partir ; stratégie d'action sur l'environnement ; un « petit-déjeuner d'atelier » servi à l'arrivée, de 7 h 45 à 8 h, dans la salle de pause ; indicateur : nombre de portions prises chaque semaine. Placards vides en fin de mois : améliorer l'accès aux produits de base ; environnement et partenariat ; convention avec l'épicerie sociale pour un panier petit-déjeuner à prix réduit ; indicateur : nombre de paniers retirés. « Trop de temps » : faire évoluer cette représentation ; éducation pour la santé ; défi « petit-déjeuner en 5 minutes » avec dégustation ; indicateur : nombre de participants au défi.

S'appuyer sur des interventions qui ont fait leurs preuves

Avant d'inventer une action, le professionnel cherche si des interventions comparables ont déjà été **évaluées**. C'est le deuxième critère de choix d'une action (efficacité). Santé publique France met en ligne un **répertoire des interventions efficaces ou prometteuses** en prévention et promotion de la santé : chaque fiche décrit l'intervention, son public, ses résultats et le niveau de preuve. Les revues de la littérature, les évaluations publiées par les instances régionales de promotion de la santé et les retours d'expérience des réseaux locaux complètent cette recherche.

Définition – Intervention probante, intervention prometteuse

Une intervention **probante** a montré son efficacité dans des évaluations de bonne qualité, si possible répétées. Une intervention **prometteuse** a donné des résultats encourageants, mais avec un niveau de preuve plus faible (évaluation unique, petit échantillon, absence de groupe de comparaison). Les deux peuvent inspirer un projet, à condition de dire clairement sur quoi l'on s'appuie.

Transférer une action : garder les fonctions clés, adapter la forme

Une intervention efficace dans un contexte ne l'est pas forcément dans un autre : le public, les ressources et l'environnement changent. Pour transférer une action, on distingue ce qui la fait marcher et ce qui peut changer. Les chercheurs parlent de **fonctions clés** (ce que l'action doit produire, par exemple « donner un savoir-faire pratique » ou « créer un soutien entre pairs ») et de **forme** (la manière concrète de le faire : durée, lieu, support, animateur). Hawe et ses collègues ont proposé cette distinction en 2004 (*British Medical Journal*) : on peut adapter la forme, à condition de préserver les fonctions clés.

Élément de l'action d'origine	Fonction clé (à garder)	Forme (adaptable)
Six ateliers culinaires de 3 heures en centre social	Pratique répétée d'un geste culinaire, avec dégustation	Quatre ateliers de 2 heures dans la cuisine d'une résidence
Recettes choisies par les participantes	Participation au choix du contenu	Recettes proposées par un comité de résidents
Animation par une diététicienne et une mère relais	Présence d'un pair qui partage l'expérience du public	Co-animation par un résident volontaire
Livret de recettes remis à la fin	Support pour refaire à la maison	Fiches avec photos et pictogrammes, ou vidéos courtes

Pour analyser la **transférabilité**, une équipe française a construit la grille ASTAIRE (Cambon et ses collègues, *BMC Public Health*, 2013). Elle invite à comparer le contexte d'origine et le nouveau contexte sur quatre familles de critères : la **population** (caractéristiques, besoins, attentes), l'**environnement** (ressources, partenaires, politiques), la **mise en œuvre** (compétences des intervenants, moyens) et le **soutien au transfert** (accompagnement, formation). Plus les écarts sont grands, plus l'adaptation doit être réfléchie et évaluée.

Astuce – Citer ses sources dans le dossier

Dans le dossier de projet et devant le jury, une phrase suffit souvent : « Cette action s'inspire de l'intervention X, décrite dans le répertoire de Santé publique France (consulté le…), dont nous avons gardé la pratique répétée et la participation, et adapté la durée et le lieu. » Elle montre que le choix est réfléchi et que l'on connaît ses limites.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.2

Une association veut reprendre, dans des villages ruraux, une action évaluée en ville : un « marché mobile » de fruits et de légumes à prix réduit, accompagné de dégustations, installé une fois par semaine au pied des immeubles. Identifiez deux fonctions clés de cette action, puis proposez deux adaptations de forme pour le milieu rural.

Corrigé

Fonctions clés : rendre les fruits et légumes **accessibles** (proximité et prix réduit) ; donner envie de les **goûter et de les cuisiner** (dégustation, idées de recettes). Adaptations de forme : une tournée qui s'arrête sur la place de chaque village à jour fixe, au moment de la sortie de l'école ou du marché existant ; une commande possible par téléphone pour les personnes qui ne se déplacent pas, avec un portage par des bénévoles ; des recettes adaptées aux produits de saison des producteurs locaux.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.1 – Les stratégies et les actions

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six stratégies d'intervention présentées dans le cours.
2. Quelles sont les sept questions de la méthode QQOQCCP ?
3. Qu'est-ce qu'une action « orpheline », et que faut-il en faire ?
4. Citez quatre des six questions qui aident à choisir une action.
5. Que signifie « garder les fonctions clés » quand on transfère une action ?
6. Pourquoi une action purement informative est-elle insuffisante, surtout auprès des publics défavorisés ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.1

1. Éducation pour la santé ; action sur l'environnement ; lien social et entourage ; participation et pouvoir d'agir ; plaidoyer ; formation des relais.
2. Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ?
3. Une action qui ne répond à aucun objectif spécifique ; on la supprime ou on la rattache explicitement à un objectif.
4. Cohérence, efficacité, adaptation au public, faisabilité, acceptabilité et participation, éthique (quatre suffisent).
5. Préserver ce qui fait l'efficacité de l'action (par exemple la pratique répétée), tout en adaptant sa forme (durée, lieu, support) au nouveau contexte.
6. L'information ne lève ni les freins d'accès (prix, offre, transport), ni le manque de savoir-faire, ni l'absence de soutien ; les personnes qui ont le plus de ressources en profitent davantage, ce qui peut creuser les inégalités.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 8.3.2.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau des stratégies et la chaîne logique.

Mon score	Ce que je fais
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 8.3.1 et je refais les exercices d'application.

8.3.2 Les parties prenantes et le partenariat

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S2 §2 (p. 10 et 11) ; Essentiels M1 S3 §1.1 (p. 13)

Définition – Partie prenante et partenaire

Une **partie prenante** est toute personne ou organisation **concernée** par le projet ou **susceptible de l'influencer** : public, professionnels, structures, élus, financeurs, commerçants. Un **partenaire** est une partie prenante qui **s'engage** dans le projet en apportant des ressources (temps, locaux, produits, financement, orientation du public) selon des modalités définies.

Cartographier et analyser les parties prenantes

Figure 8.1 – La matrice pouvoir/intérêt des parties prenantes

Comprendre le schéma – Figure 8.1

1. Chaque partie prenante est placée selon son **pouvoir** (capacité à décider, financer, bloquer) et son **intérêt** pour le projet (d'après la grille de Mendelow).

2. Pouvoir fort, intérêt fort (ARS financeur, direction et référente du centre social) : à **gérer étroitement** ; ils siègent au comité de pilotage et participent aux décisions.

3. Pouvoir fort, intérêt faible (élus, direction de la CAF) : à **satisfaire** ; on les informe des avancées et on les consulte sur les décisions qui les concernent (communication institutionnelle, invitation au temps fort).

4. Pouvoir faible, intérêt fort (familles, mamans relais, bénévoles) : à **associer** et tenir informés ; ce sont les premiers concernés, leur participation est une exigence (chapitre 6).

5. Pouvoir faible, intérêt faible (commerces voisins) : à **surveiller**, avec une information minimale ; leur position peut évoluer (un commerce peut devenir partenaire).

6. La matrice est **dynamique** : on la met à jour au cours du projet.

Répartir les rôles : la matrice RACI

Tâche	Inès (étudiante)	Diététicienne	Référente familles	Épicerie	COPIL
Diagnostic	R	C	A	C	I
Dossier d'appel à projets	R	C	A	I	I
Conception des ateliers	R	C	A	I	–
Animation ateliers 1 à 3	R	R	A	–	–
Animation ateliers 4 à 6	C	R	A	–	–
Orientation des familles	I	I	R	R	–
Évaluation	R	C	A	I	I
Validation des étapes	C	C	R	C	A

R = réalise ; A = approuve, rend compte (une seule personne A par tâche) ; C = consulté ; I = informé.

Formaliser le partenariat

Outil	Contenu
Convention de partenariat	Objet ; engagements de chaque partie (ressources, moyens, temps) ; durée ; communication (logos, mentions) ; confidentialité et RGPD ; évaluation ; conditions de résiliation ; signatures
Comité de pilotage (COPIL)	Instance de décision : porteur, partenaires principaux, financeurs, représentants des usagers ; 2 à 3 réunions (lancement, mi-parcours, bilan)
Comité technique / équipe projet	Instance d'organisation et de mise en œuvre ; réunions fréquentes ; suivi du tableau de bord
Comité d'usagers	Participation des personnes concernées (choix des thèmes, avis sur les supports)

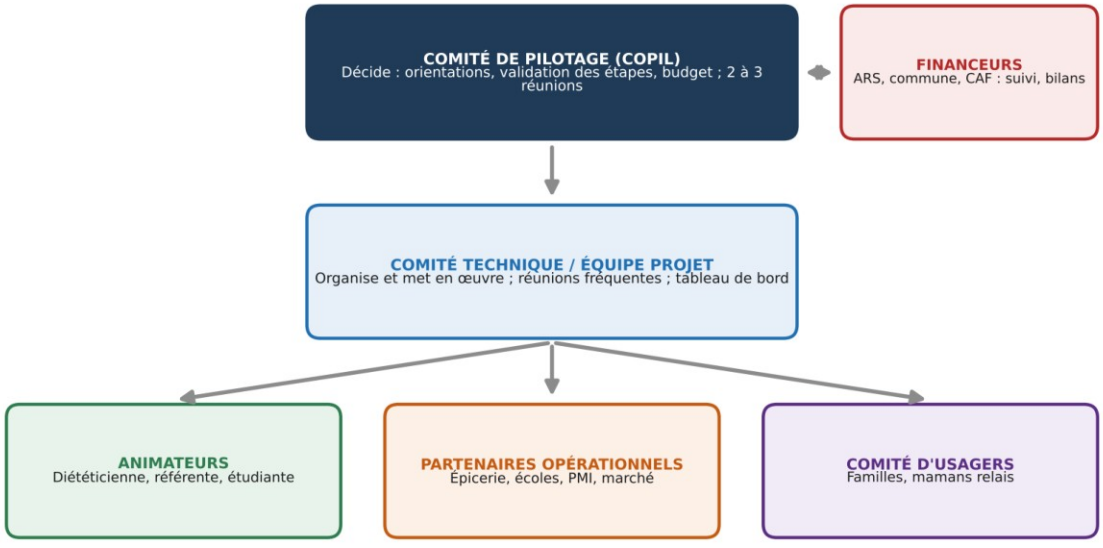


Figure 8.2 – L'organisation du pilotage d'un projet

Attention – Un partenariat se construit

Un partenaire ne s'implique que s'il y trouve un **intérêt** pour sa propre mission (l'épicerie veut que les légumes secs soient utilisés ; l'école veut associer les parents). Présenter le projet en montrant ce qu'il **apporte** au partenaire, rester disponible, respecter ses contraintes, l'associer aux décisions et lui **restituer** les résultats sont les clés d'un partenariat durable.

Analyser chaque partie prenante en profondeur

La matrice pouvoir/intérêt donne une vue d'ensemble. Pour les parties prenantes les plus importantes, on va plus loin avec une **fiche d'analyse** : que veut cette personne ou cette structure ? Que peut-elle apporter ? Que craint-elle ? Comment l'associer ? Ce travail évite deux erreurs fréquentes : supposer que tout le monde partage les objectifs du projet, et oublier une partie prenante capable de le bloquer.

Question	Ce que l'on cherche	Exemple : le principal d'un collège sollicité pour un projet sur le petit-déjeuner
Quelle est sa mission ?	Ce qui guide ses décisions	Réussite des élèves, sécurité, relations avec les familles
Quel intérêt peut-il trouver au projet ?	Le point de rencontre avec ses propres objectifs	Moins de malaises et de baisses d'attention en fin de matinée
Que peut-il apporter ?	Les ressources concrètes	Une salle, un créneau dans l'emploi du temps, l'accord pour informer les parents
Que craint-il ?	Les freins, souvent non dits	Surcharge des équipes, responsabilité en cas d'allergie, réaction des parents
Quel est son pouvoir sur le projet ?	Sa capacité à décider ou à bloquer	Il peut refuser l'accès à l'établissement
Comment l'associer ?	La modalité adaptée	Le rencontrer avant tout dépôt de dossier ; l'inviter au comité de pilotage ; lui proposer un protocole allergies écrit

Méthode pas à pas – Préparer la rencontre avec un futur partenaire

1. Se renseigner sur la structure : missions, public, projets en cours, personnes à rencontrer.

2. Préparer un message court : le constat (deux ou trois chiffres), l'objectif du projet, ce que l'on attend du partenaire, et surtout ce que le projet peut lui apporter.

3. Écouter ses contraintes et ses craintes avant de proposer des solutions.

4. Proposer un engagement précis et limité (une salle deux matins par mois, une orientation de familles) plutôt qu'une participation vague.

5. Laisser une trace : un courriel de remerciement qui reprend ce qui a été convenu, puis, si l'engagement se confirme, une lettre d'engagement ou une convention.

Attention – Les parties prenantes « cachées »

Certaines parties prenantes ne figurent sur aucun organigramme, mais elles comptent : l'agent d'entretien qui ferme la salle à 17 h, la gardienne d'immeuble qui connaît toutes les familles, la secrétaire qui gère les réservations, le conjoint qui décide des courses. Les oublier peut faire échouer une action bien conçue. Pendant le diagnostic, on demande systématiquement : « Qui d'autre pourrait aider ou gêner ce projet ? »

Exemple – Une crainte levée, un partenaire gagné

Une diététicienne voulait organiser des dégustations de fruits dans le hall d'une maison de santé. Le médecin coordinateur hésitait. En l'écoutant, elle a compris qu'il craignait la gêne pour les patients en salle d'attente et le risque d'hygiène. Elle a proposé un créneau le mercredi après-midi, quand il n'y a pas de consultation, avec des fruits préparés devant le public sur un plan de travail désinfecté. Le médecin a accepté et a proposé lui-même d'orienter ses patients diabétiques vers l'atelier suivant.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.3

Un service de santé au travail veut installer des fontaines à eau et un distributeur de fruits dans une blanchisserie industrielle (fictive). Remplissez la fiche d'analyse (mission, intérêt, apport, crainte, pouvoir, modalité) pour deux parties prenantes : le directeur de l'entrepôt et les représentants du personnel.

Corrigé

Directeur : mission, productivité et sécurité ; intérêt, moins d'accidents et d'absences liés à la fatigue et à la déshydratation ; apport, financement et emplacement des équipements ; crainte, coût et temps de pause supplémentaire ; pouvoir fort (il décide) ; modalité, le rencontrer avec des chiffres (relevé des malaises, coût d'une fontaine) et l'inviter au comité de pilotage. Représentants du personnel : mission, défendre la santé et les conditions de travail des salariés ; intérêt fort ; apport, relais auprès des équipes et connaissance des postes ; crainte, que l'action serve à surveiller les pauses ou culpabilise les salariés ; pouvoir moyen (ils peuvent soutenir ou dénoncer le projet) ; modalité, les associer dès le diagnostic et à la rédaction des messages.

Faire vivre le partenariat dans la durée

Signer une convention ne suffit pas. Un partenariat se **construit**, s'**entretient** et se **termine** proprement. Trois outils l'organisent, du plus léger au plus formel.

Outil	Quand l'utiliser	Contenu
Courriel de confirmation	Après une première rencontre, pour un engagement ponctuel	Ce qui a été convenu, les dates, le contact
Lettre d'engagement (ou lettre de soutien)	Pour un dossier de financement : elle prouve au financeur que le partenaire s'engage	Nom et signature du responsable, nature de l'engagement (orientation, locaux, temps, produits), durée
Convention de partenariat	Pour un engagement durable ou qui comporte des moyens importants, des données ou de l'argent	Objet, engagements, durée, communication, données, suivi, résiliation, signatures (8.3.12)

Prévenir et gérer les désaccords

Les partenaires n'ont pas les mêmes contraintes ni le même calendrier. Des tensions apparaissent souvent sur quatre sujets : le **partage du travail** (« c'est toujours nous qui faisons tout »), la **visibilité** (« notre logo n'apparaît pas »), le **calendrier** (« vous nous prévenez trop tard ») et les **résultats** (« on ne sait jamais ce que deviennent les familles qu'on vous envoie »). On les prévient en écrivant les engagements de chacun, en partageant le calendrier dès le début, en validant ensemble les supports et en restituant régulièrement les résultats, sous une forme agrégée et anonyme.

Méthode pas à pas – Traiter un désaccord entre partenaires

1. **Séparer les faits des interprétations** : qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
2. **Écouter chaque point de vue** sans chercher un coupable, de préférence en réunion et non par courriel.
3. **Revenir à l'objectif commun** et aux engagements écrits.
4. **Chercher une solution** qui respecte les contraintes de chacun, puis la noter dans le compte rendu (qui fait quoi, pour quand).
5. **Si le désaccord persiste**, le porter au comité de pilotage, qui arbitre.

Lien diététique – Le diététicien, partenaire et non prestataire

Quand une structure sollicite un diététicien pour « faire un atelier », le risque est de devenir un simple prestataire, sans lien avec le reste du projet. Le diététicien gagne à demander où se situe l'atelier dans le projet, quels objectifs il sert, qui sont les participants et comment les résultats seront suivis. Il devient alors un partenaire qui contribue à la cohérence de l'ensemble. La participation des personnes concernées aux instances, et ses exigences éthiques, sont traitées au chapitre 6.

Exemple – Une fin de partenariat bien gérée

Une épicerie solidaire qui orientait des familles vers des ateliers a dû réduire son activité faute de bénévoles. Plutôt que de laisser le partenariat s'éteindre sans explication, la coordinatrice du projet a proposé une dernière réunion : bilan des orientations (23 familles en deux ans), remerciements écrits, mention du partenariat dans le rapport annuel et accord pour reprendre contact si l'épicerie retrouvait des bénévoles. Un an plus tard, l'épicerie a repris les orientations.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.4

Une PMI oriente depuis six mois des familles vers les ateliers d'un centre social. L'infirmière puéricultrice se plaint : « On ne sait jamais si les familles sont venues, ni ce qu'elles en ont pensé. » Proposez trois mesures pour répondre à cette plainte, en respectant la confidentialité.

Corrigé

Exemples : transmettre chaque trimestre un bilan agrégé (nombre de familles orientées par la PMI, nombre venues, taux de présence, satisfaction globale), sans nom ; proposer aux familles, avec leur accord écrit, que le centre social informe la PMI de leur participation ; inviter l'infirmière à un atelier ou au comité de pilotage et présenter les résultats lors d'une réunion commune ; prévoir ce retour dans la convention (article « suivi et évaluation »).

Repères – Les acteurs d'une politique de santé et le conducteur de séance (CNED)

- **Quatre types d'acteurs** (CNED, Essentiels, séquence 3) : les acteurs **consultatifs** donnent un avis (HCSP, CNS, CRSA, Conseil national de l'alimentation) ; les acteurs **décideurs** prennent les décisions (État, ministères, Parlement, ARS) ; les acteurs **opérateurs** mettent en œuvre (Santé publique France, collectivités, associations, professionnels de santé) ; les acteurs **financeurs** paient (Assurance maladie, État, collectivités, mutuelles). Dans la matrice pouvoir/intérêt, un même partenaire peut jouer plusieurs rôles : une ARS décide, finance par le FIR et siège au comité de pilotage.
- **Parties prenantes** (CNED, séquence 2) : l'équipe du projet, les partenaires (appui humain, logistique, matériel ou financier, ponctuel ou régulier) et les usagers, futurs bénéficiaires du projet.
- **Conducteur de séance** (guide 2025, p. 63) : c'est le plan minuté d'une séance d'atelier (étapes, durées, activités, méthodes, rôles, matériel, évaluation). Le plan d'action dit **quels** ateliers ont lieu et **quand** ; le conducteur dit **comment** se déroule chacun. Il est traité en détail au chapitre 10.
- **Communication et valorisation** : elles accompagnent toute la vie du projet ; le plan de communication (8.3.7) les prévoit dès la conception.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.2 – Les parties prenantes et le partenariat

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la différence entre une partie prenante et un partenaire ?

2. Dans la matrice pouvoir/intérêt, que fait-on des parties prenantes à pouvoir fort et à intérêt faible ?

3. Dans une matrice RACI, combien de personnes peuvent être « A » pour une même tâche ?

4. Quel est le rôle du comité de pilotage ? Celui du comité technique ?
5. À quoi sert une lettre d'engagement dans un dossier de financement ?
6. Citez trois sujets fréquents de désaccord entre partenaires.

Corrigé – Point d'étape 8.3.2

1. Une partie prenante est concernée par le projet ou peut l'influencer ; un partenaire s'engage et apporte des ressources selon des modalités définies.
2. On les satisfait : on les informe des avancées et on les consulte sur les décisions qui les concernent.
3. Une seule.
4. Le comité de pilotage décide et arbitre ; le comité technique organise, suit le tableau de bord et prépare les décisions.
5. Elle prouve au financeur que le partenaire s'engage réellement (nature, durée, signature du responsable).
6. Le partage du travail, la visibilité, le calendrier, le retour sur les résultats (trois suffisent).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 8.3.3.
3 ou 4 sur 6	Je relis la matrice pouvoir/intérêt et la matrice RACI.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 8.3.2 et je refais les exercices d'application.

8.3.3 Les financements et les appels à projets

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S3 §1.1 (p. 13)

Qui finance la prévention en nutrition ?

Financeur	Ce qu'il finance	Modalités
ARS – fonds d'intervention régional (FIR)	Actions de prévention et de promotion de la santé conformes au PRS (nutrition, publics prioritaires, QPV) ; le FIR est prévu par l'article L. 1435-8 du CSP	Appels à projets annuels, subventions, contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM)
Collectivités (commune, intercommunalité, département, région)	Actions inscrites dans le CLS, le contrat de ville, le PAT ; restauration collective ; protection maternelle et infantile (département)	Subventions, appels à projets, mise à disposition de locaux
Caisse d'allocations familiales (CAF)	Animation collective familles des centres sociaux, soutien à la parentalité (REAAP)	Prestations de service, appels à projets
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie (loi du 28 décembre 2015)	Actions de prévention pour les 60 ans et plus (nutrition, activité physique, lien social)	Appels à projets départementaux
Assurance maladie, mutuelles, caisses de retraite	Prévention, ateliers collectifs, programmes « bien vieillir »	Appels à projets, partenariats
Fondations et mécénat	Projets innovants, précarité alimentaire, enfance	Appels à projets ; attention aux conflits d'intérêts (chapitre 6)
État (politique de la ville, alimentation)	Actions en QPV (contrat de ville) ; programmes de lutte contre la précarité alimentaire	Appels à projets nationaux ou déconcentrés

Définition – Appel à projets

Procédure par laquelle un financeur définit, dans un **cahier des charges**, des **priorités**, des **publics**, des **critères d'éligibilité et de sélection**, un **calendrier** et un **montant** disponible, et invite les porteurs à déposer un dossier. Les dossiers sont évalués par un comité selon une grille ; les projets retenus reçoivent une subvention et s'engagent à rendre un **bilan** (compte rendu financier et d'activité).

Méthode pas à pas – Répondre à un appel à projets en 7 étapes

1. Lire le cahier des charges en entier et surligner : priorités, publics, territoires, actions éligibles et **exclues**, montant maximal, cofinancement exigé, date limite, pièces à joindre, critères de sélection.

2. Vérifier l'éligibilité du porteur (association déclarée, numéro SIRET, compte bancaire) et du projet.

3. Faire correspondre le projet aux priorités : reprendre le **vocabulaire** du financeur (PRS, publics prioritaires, réduction des inégalités).

4. Rédiger : contexte et diagnostic chiffré, objectifs SMART, actions détaillées, partenaires (lettres d'engagement), calendrier, évaluation (indicateurs), budget équilibré avec cofinancements.

5. Remplir le formulaire (souvent le Cerfa n° 12156 de demande de subvention des associations, ou la plateforme en ligne du financeur, par exemple Le Compte Asso).

6. Faire relire (référente, partenaire) et vérifier la cohérence entre objectifs, actions, indicateurs et budget.

7. Déposer avant la date limite et garder une preuve du dépôt ; préparer le bilan dès le début (indicateurs à suivre).

Ce qui fait gagner des points	Ce qui fait perdre un dossier
Diagnostic local chiffré et sourcé	Contexte général sans données locales
Objectifs SMART reliés aux constats	Objectifs flous (« sensibiliser »)
Public prioritaire du financeur, participation des personnes	Public non précisé
Partenariats concrets (lettres d'engagement)	Partenaires cités sans engagement
Évaluation prévue avec indicateurs	Évaluation absente ou vague
Budget détaillé, équilibré, cofinancé	Budget incohérent, financeur unique à 100 %
Pérennisation envisagée	Projet « one shot »

Analyser un cahier des charges avec une grille

Un cahier des charges se lit avec un crayon. Les dossiers rejetés le sont souvent pour une raison simple : un public hors cible, une action exclue, une durée trop longue, une pièce manquante ou un dépôt en retard. La grille suivante aide à ne rien oublier. On la remplit avant de rédiger, puis on la relit avant de déposer.

Rubrique	Question à se poser	Où trouver la réponse
Porteurs éligibles	Notre structure peut-elle déposer (statut, ancienneté, territoire) ?	Article « bénéficiaires » ou « éligibilité »
Publics prioritaires	Notre public correspond-il exactement ? Faut-il le préciser ou le recentrer ?	Article « publics »
Actions éligibles et exclues	Nos actions sont-elles financées ? Certaines sont-elles exclues (investissement, consultations individuelles, distribution seule) ?	Articles « actions » et « exclusions »
Durée et calendrier	Le projet tient-il dans la période ? Quand commence-t-il au plus tôt ?	Article « calendrier »

Rubrique	Question à se poser	Où trouver la réponse
Montant	Quel taux, quel plafond, quelle assiette (base de calcul) ? Un cofinancement est-il exigé ?	Article « financement »
Dépenses éligibles	Les contributions en nature, le matériel, les frais de structure sont-ils pris en compte ?	Annexe financière
Critères de sélection	Sur quoi le comité note-t-il ? Avec quel poids ?	Article « sélection » ou grille jointe
Pièces et modalités	Quel formulaire, quelle plateforme, quelles pièces jointes, quelle date et quelle heure limite ?	Article « dépôt »
Engagements	Quel bilan, à quelle date, avec quels indicateurs ?	Article « suivi »

Calculer le montant à demander

Le montant d'une subvention dépend de trois éléments : l'**assiette** (les dépenses que le financeur accepte de prendre en compte), le **taux** maximal et le **plafond**. La subvention possible est le plus petit des deux montants : taux × assiette, ou plafond.

Exemple – Calcul détaillé : montant d'une subvention et cofinancement

Un appel à projets (fictif) finance 70 % au plus des dépenses éligibles, dans la limite de 5 000 €. Il exclut les contributions en nature et l'achat de matériel de plus de 300 €. Le projet compte 6 800 € de charges monétaires, dont un réfrigérateur de 400 €, et 900 € de contributions en nature.

- Dépenses éligibles : 6 800 − 400 = **6 400 €** (les contributions en nature ne sont pas dans les charges monétaires ; le réfrigérateur est exclu).
- Taux appliqué : 70 % × 6 400 = **4 480 €**, inférieur au plafond de 5 000 € : subvention maximale **4 480 €**.
- Cofinancement nécessaire pour les charges monétaires : 6 800 − 4 480 = **2 320 €**, soit 2 320 / 6 800 × 100 = **34,1 %**. Il viendra d'autres financeurs, de la participation des personnes et de l'autofinancement. Le réfrigérateur doit être financé par d'autres ressources.

Attention – Demander le maximum n'est pas toujours la meilleure stratégie

Un dossier qui demande exactement le plafond, sans cofinancement solide, inquiète le comité : il montre une forte dépendance à un seul financeur. Un montant justifié ligne par ligne, avec des cofinancements acquis, est plus convaincant. Il faut aussi vérifier que la structure pourra avancer les dépenses avant le versement (8.3.10).

À vous de jouer – Exercice d'application 8.5

Avec les règles de l'exemple (70 % des dépenses éligibles, plafond de 5 000 €, matériel de plus de 300 € exclu), calculez la subvention maximale d'un projet de 9 200 € de charges monétaires, dont un four de 600 €. Calculez ensuite le cofinancement nécessaire en euros et en pourcentage des charges monétaires.

Corrigé

Dépenses éligibles : 9 200 − 600 = **8 600 €** ; 70 % × 8 600 = 6 020 €, supérieur au plafond : subvention maximale **5 000 €**. Cofinancement : 9 200 − 5 000 = **4 200 €**, soit 4 200 / 9 200 × 100 = **45,7 %** des charges monétaires. Le plafond limite ici la subvention : le porteur doit trouver près de la moitié du financement ailleurs.

Le formulaire de demande et les pièces à joindre

Les associations qui demandent une subvention à l'État, à une collectivité ou à un organisme public utilisent le plus souvent le **formulaire Cerfa n° 12156** (« Demande de subvention(s) »), sur papier ou en ligne. Le service en ligne **Le Compte Asso** permet de remplir ce formulaire et de déposer les pièces une seule fois pour plusieurs financeurs. Certains financeurs (ARS, fondations, caisses) utilisent leur propre plateforme : le cahier des charges le précise.

Partie du dossier	Ce qu'on y met	Conseil
Identification de l'association	Nom, numéro RNA (répertoire national des associations), numéro SIRET, adresse, représentant légal, personne chargée du dossier	Vérifier que les numéros sont à jour avant la date limite : leur obtention peut prendre plusieurs semaines
Moyens humains	Nombre de salariés, de bénévoles, de personnes mises à disposition	Cohérence avec le budget du projet
Budget de l'association	Budget prévisionnel de l'année	Il montre la solidité financière du porteur
Description du projet	Contexte, objectifs, public, actions, partenaires, calendrier, moyens, évaluation	Reprendre la chaîne logique et le vocabulaire du financeur
Budget du projet	Charges et produits par compte, contributions en nature	Équilibré ; financements acquis et sollicités distingués
Attestations	Déclaration sur l'honneur du représentant, montant demandé, engagement à respecter le contrat d'engagement républicain	Signée par le représentant légal ou par une personne qu'il a déléguée
Pièces jointes	Statuts, liste des dirigeants, relevé d'identité bancaire, derniers comptes approuvés, rapport d'activité	Préparer un dossier de pièces à jour, réutilisable

Depuis la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, une association qui demande une subvention publique s'engage, en signant le **contrat d'engagement républicain**, à respecter notamment la liberté de conscience, l'égalité, la dignité de la personne et l'ordre public. Cet engagement figure dans le formulaire.

Rédiger la description du projet : ce qui convainc

Rubrique	Ce qui convainc le comité	Ce qui l'inquiète
Contexte	Trois ou quatre chiffres locaux, datés et sourcés ; les besoins exprimés par le public	Des généralités nationales, des adjectifs (« alarmant »)
Objectifs	Un objectif général, des objectifs spécifiques SMART reliés aux constats	« Sensibiliser », « informer », sans valeur cible
Actions	Des actions décrites (QQOQCCP), qui combinent plusieurs stratégies	Une liste d'ateliers sans lien avec les objectifs
Public et participation	Un nombre de personnes, un mode de recrutement, une participation au choix des actions	« Tout public », ou un public qui ne correspond pas aux priorités
Partenaires	Des engagements précis, avec lettres jointes	Une liste de noms sans engagement
Évaluation	Des indicateurs de processus et de résultat, une méthode de recueil	Une évaluation limitée à la satisfaction
Budget	Des lignes justifiées (quantité × coût unitaire), un cofinancement	Une ligne « divers » importante, un financeur unique

Astuce – Le résumé en cinq lignes

Beaucoup de plateformes demandent un résumé du projet en quelques lignes. C'est souvent le seul texte que tous les membres du comité lisent en entier. Écrivez-le en dernier, et répondez dans l'ordre à cinq questions : quel problème, pour qui, quelles actions, avec qui, quels résultats attendus.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.6

Réécrivez ce résumé pour le rendre convaincant : « Notre association souhaite sensibiliser les habitants à l'importance d'une bonne alimentation, car la malbouffe est un fléau. Nous organiserons des ateliers. »

Données disponibles : quartier de 3 400 habitants ; 44 % des 120 familles interrogées en 2026 disent manquer d'idées de repas à petit prix ; projet de huit ateliers pour 12 familles, avec l'épicerie sociale et la PMI ; objectif : que la moitié des familles cuisinent au moins deux nouveaux plats à base de légumes chaque mois.

Corrigé

Exemple : « Dans le quartier des Peupliers (3 400 habitants), 44 % des 120 familles interrogées en 2026 disent manquer d'idées de repas à petit prix. Avec l'épicerie sociale et la PMI, notre association propose à 12 familles huit ateliers culinaires construits avec elles, à partir des produits disponibles à l'épicerie. Nous visons qu'à la fin du cycle, au moins la moitié des familles cuisinent chaque mois au moins deux nouveaux plats à base de légumes. Les présences et les pratiques seront mesurées avant et après le cycle. » Les mots « malbouffe » et « fléau » sont supprimés : ils jugent les personnes sans rien prouver.

Après la décision : convention, versements et compte rendu

Obtenir une subvention crée des **obligations**. Le porteur doit utiliser l'argent pour le projet décrit, dans la période prévue, et en rendre compte. Les connaître dès la conception évite de mauvaises surprises au moment du bilan.

Étape	Ce qui se passe	Ce que fait le porteur
Notification	Le financeur informe de sa décision et du montant accordé, parfois inférieur à la demande	Si le montant est réduit, il ajuste le projet ou cherche un complément, et il le signale
Convention ou arrêté attributif	Document qui fixe l'objet, le montant, le calendrier des versements et les obligations. Pour l'État et les collectivités, une convention est obligatoire au-delà de 23 000 € par an (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, article 10, et décret n° 2001-495 du 6 juin 2001)	Il la lit, la signe et note les dates de bilan
Versements	Souvent un acompte à la signature, le solde après le bilan	Il met à jour le plan de trésorerie (8.3.10)
Mise en œuvre	Le projet se déroule	Il conserve les justificatifs (factures, feuilles de temps, émargements) et signale toute modification importante
Compte rendu	Un compte rendu financier (formulaire Cerfa n° 15059 pour les subventions publiques) et un bilan d'activité	Il compare le prévu et le réalisé, explique les écarts et présente les résultats des indicateurs

Le compte rendu financier doit être transmis dans les **six mois** qui suivent la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée (article 10 de la loi du 12 avril 2000). Une subvention qui n'a pas été utilisée conformément à son objet peut devoir être **remboursée**. Les justificatifs sont conservés : le financeur peut les demander lors d'un contrôle.

Attention – Modifier un projet subventionné

Changer de public, réduire fortement le nombre d'actions, prolonger la durée ou utiliser une ligne de budget pour une autre dépense importante : ces modifications doivent être signalées au financeur **avant** d'être appliquées, par un courrier motivé. Selon leur importance, elles peuvent donner lieu à un avenant à la convention. Un financeur informé à temps accepte souvent un ajustement ; un financeur qui le découvre au bilan peut demander un remboursement.

Exemple – Un compte rendu financier commenté (extrait)

« La subvention de 2 400 € de la communauté de communes (projet fictif) a financé 85 % des denrées et la totalité des honoraires de la diététicienne. Le poste denrées présente un dépassement de 11,2 % (prix des fruits au printemps), compensé par une économie sur l'impression. Le total réalisé (5 960 €) est supérieur de 1,9 % au budget prévu. Sept ateliers sur huit ont eu lieu ; le huitième a été remplacé, avec l'accord écrit du financeur du 14 mai, par une visite du marché. »

À vous de jouer – Exercice d'application 8.7

Une association a reçu 3 000 € d'une collectivité pour six ateliers destinés à des personnes âgées. En cours de projet, la salle devient indisponible et l'association pense remplacer deux ateliers par une sortie au marché. Indiquez ce qu'elle doit faire, dans quel ordre, et ce qu'elle devra présenter dans son compte rendu.

Corrigé

1. Évaluer la modification : la sortie au marché sert-elle les mêmes objectifs ? Quel est son coût ? 2. Écrire au financeur **avant** la modification : constat (salle indisponible), proposition, effet sur le budget, demande d'accord. 3. Attendre sa réponse écrite (éventuellement un avenant), puis informer les participants et les partenaires. 4. Dans le compte rendu : quatre ateliers et la sortie réalisés, l'accord du financeur et sa date, les dépenses comparées au budget prévu avec l'explication des écarts, les résultats des indicateurs.

Les courriers qui accompagnent un projet

Au cours d'un projet, le chef de projet rédige plusieurs courriers : une **demande de lettre de soutien** à un partenaire, une **lettre de soutien** à faire signer, une **demande d'acompte** au financeur, un **courrier d'information** en cas de modification du projet. Ces écrits suivent les règles du courrier professionnel : expéditeur, destinataire, date, objet, formule d'appel, corps du texte en paragraphes courts, formule de politesse, signature de la personne habilitée.

Définition – Lettre de soutien

Courrier par lequel un partenaire (collectivité, association, professionnel) atteste qu'il connaît le projet, qu'il en partage les objectifs et, le plus souvent, qu'il s'engage à y contribuer d'une manière précise. Elle est jointe au dossier de financement. Une lettre de soutien utile est **précise** : elle dit ce que le partenaire apporte (orientation de familles, prêt de salle, temps de professionnel).

Exemple – Une demande d'acompte au financeur (structure et montants fictifs)

« Objet : demande de versement d'un acompte – projet "Cuisiner ensemble à la Grange".

Madame la Directrice,

Par décision du 12 septembre 2027, vous avez attribué à notre association une subvention de 1 500 € pour le projet cité en objet, qui se déroule d'octobre 2027 à mai 2028. Les achats de matériel de cuisine, d'un montant de 650 €, doivent être réalisés en octobre, avant le premier atelier. Notre plan de trésorerie, joint à

ce courrier, montre un solde négatif de 520 € fin octobre si la subvention est versée en totalité à la fin du projet.

Nous sollicitons donc le versement d'un acompte de 50 %, soit 750 €, dès la signature de la convention. Le solde serait versé après la remise du compte rendu financier.

Nous restons à votre disposition pour tout complément et vous prions d'agréer, Madame la Directrice, l'expression de nos salutations distinguées.

La présidente de l'association »

Méthode – Informer un financeur d'une modification du projet

1. **Prévenir avant** de modifier, et non après, dès que l'écart est connu (8.3.6).
2. **Décrire** l'écart avec précision : ce qui était prévu, ce qui change, pourquoi.
3. **Montrer** que les objectifs restent atteignables, ou proposer de nouveaux objectifs réalistes.
4. **Chiffrer** l'effet sur le budget, en restant dans les règles de la convention (une modification importante peut nécessiter un avenant).
5. **Demander** l'accord écrit du financeur et le conserver avec la convention.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.8

Vous avez besoin d'une lettre de soutien de la PMI pour un projet d'ateliers « premiers repas » destinés aux parents de bébés de 4 à 12 mois. Rédigez les trois engagements précis que vous proposez à la PMI d'inscrire dans la lettre.

Corrigé

Exemples d'engagements précis : 1. Les puéricultrices de la PMI présentent les ateliers aux parents lors des consultations et remettent le flyer, pendant toute la durée du projet. 2. La PMI met à disposition sa salle d'activités un mercredi matin par mois, d'octobre à mars. 3. Une puéricultrice participe à deux ateliers sur six pour répondre aux questions sur le développement de l'enfant, et participe au comité de pilotage. Chaque engagement dit qui fait quoi, quand et combien, ce qui le rend vérifiable.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.3 – Les financements et les appels à projets

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez quatre financeurs possibles d'un projet de prévention en nutrition.
2. Quel financeur s'adresse spécifiquement aux actions de prévention pour les personnes de 60 ans et plus ?
3. Une subvention est plafonnée à 3 000 € et à 60 % de 4 000 € de dépenses éligibles. Quel montant peut-on demander au plus ?
4. Quel formulaire utilise-t-on le plus souvent pour une demande de subvention associative ? Et pour le compte rendu financier ?
5. Dans quel délai le compte rendu financier d'une subvention publique doit-il être transmis ?
6. Que faire si l'on doit modifier un projet subventionné ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.3

1. ARS (fonds d'intervention régional), collectivités, CAF, conférence des financeurs, Assurance maladie, mutuelles, caisses de retraite, fondations, État (quatre suffisent).
2. La conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie (loi du 28 décembre 2015).

3. 60 % × 4 000 = 2 400 €, inférieur au plafond : **2 400 €**.
4. Le Cerfa n° 12156 pour la demande ; le Cerfa n° 15059 pour le compte rendu financier.
5. Dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée.
6. Le signaler au financeur avant de l'appliquer, par un courrier motivé, et attendre son accord (éventuellement un avenant).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 8.3.4.
3 ou 4 sur 6	Je relis la grille d'analyse du cahier des charges et le calcul de la subvention.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 8.3.3 et je refais les exercices d'application.

8.3.4 Planifier le projet

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Le diagramme de Gantt

Définition – Diagramme de Gantt

Représentation graphique du calendrier d'un projet (Henry Gantt, vers 1910) : les **tâches** sont en lignes, le **temps** en colonnes ; chaque tâche est une barre dont la position et la longueur indiquent sa date de début et sa durée. On y ajoute les **jalons** (dates clés : dépôt du dossier, premier atelier, comité de pilotage) et les **dépendances** entre tâches (fiche **F5** ; tableur de stage, feuille Gantt).

Le réseau PERT et le chemin critique

Le réseau **PERT** (*Program Evaluation and Review Technique*, 1958) représente les tâches et leurs **antériorités** (« la tâche C ne peut commencer que lorsque B est terminée »). Il permet de calculer la **durée minimale** du projet et d'identifier le **chemin critique** : la suite de tâches sans marge, dont tout retard retarde le projet entier.

Tâche	Intitulé	Durée	Antériorités
A	Diagnostic	2 sem.	–
B	Objectifs et choix des actions	1 sem.	A
C	Rédaction et dépôt du dossier d'appel à projets	2 sem.	B
D	Recherche et conventions de partenariat	3 sem.	A
E	Communication et inscriptions	2 sem.	C, D
F	Préparation des ateliers (conducteurs, fiches, achats)	3 sem.	C
G	Ateliers (6 séances + visite du marché)	10 sem.	E, F
H	Évaluation et bilan	2 sem.	G

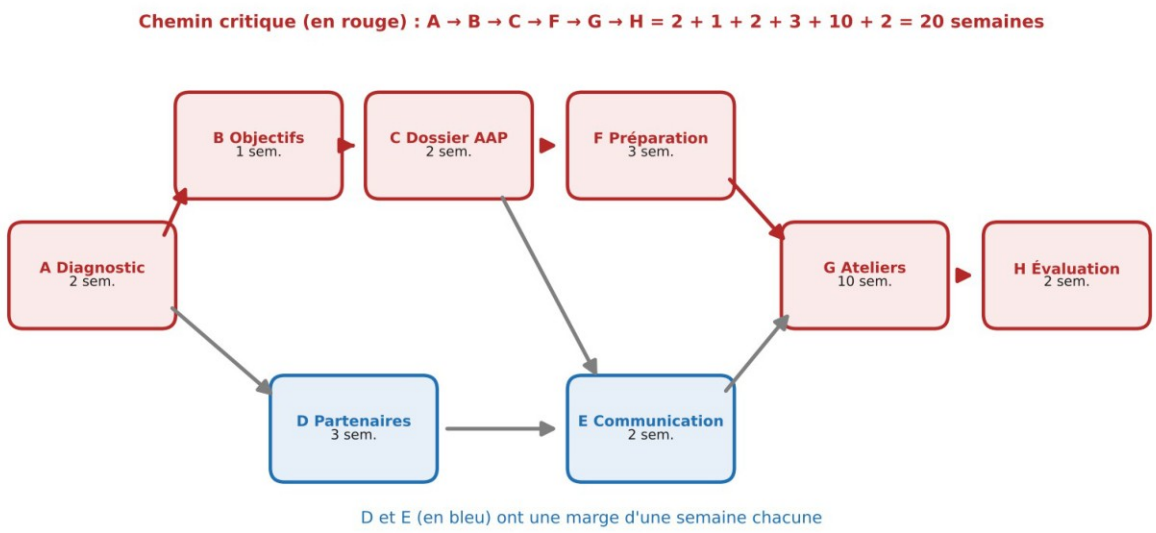


Figure 8.3 – Réseau PERT et chemin critique

Exemple – Calcul détaillé des dates au plus tôt, au plus tard et des marges

Dates au plus tôt (on avance de gauche à droite ; une tâche commence quand **toutes** ses antériorités sont finies, donc au **maximum** de leurs fins) :

- A : début 0, fin 0 + 2 = **2**. B : début 2, fin 3. D : début 2, fin 2 + 3 = **5**. C : début 3, fin 5.
- E : début = max(fin C ; fin D) = max(5 ; 5) = 5, fin **7**. F : début 5, fin **8**.
- G : début = max(fin E ; fin F) = max(7 ; 8) = 8, fin 8 + 10 = **18**. H : début 18, fin **20**.

Durée minimale du projet : 20 semaines. Dates au plus tard (on recule de droite à gauche ; fin au plus tard = **minimum** des débuts au plus tard des tâches suivantes) :

- H : fin 20, début 18. G : fin 18, début 8. F : fin 8, début 5. E : fin 8, début 6.
- C : fin = min(début F ; début E) = min(5 ; 6) = 5, début 3. D : fin = début E = 6, début 3. B : fin 3, début 2. A : fin = min(début B ; début D) = min(2 ; 3) = 2, début 0.

Marges (date au plus tard − date au plus tôt) : A, B, C, F, G, H : **0** → chemin critique **A → B → C → F → G → H** (2 + 1 + 2 + 3 + 10 + 2 = 20 semaines). D : 3 − 2 = **1 semaine** ; E : 6 − 5 = **1 semaine**. **Conséquence pratique** : un retard d'une semaine dans la recherche de partenaires (D) est absorbé ; un retard d'une semaine dans le dépôt du dossier (C) décale tout le projet. On surveille donc en priorité les tâches critiques.

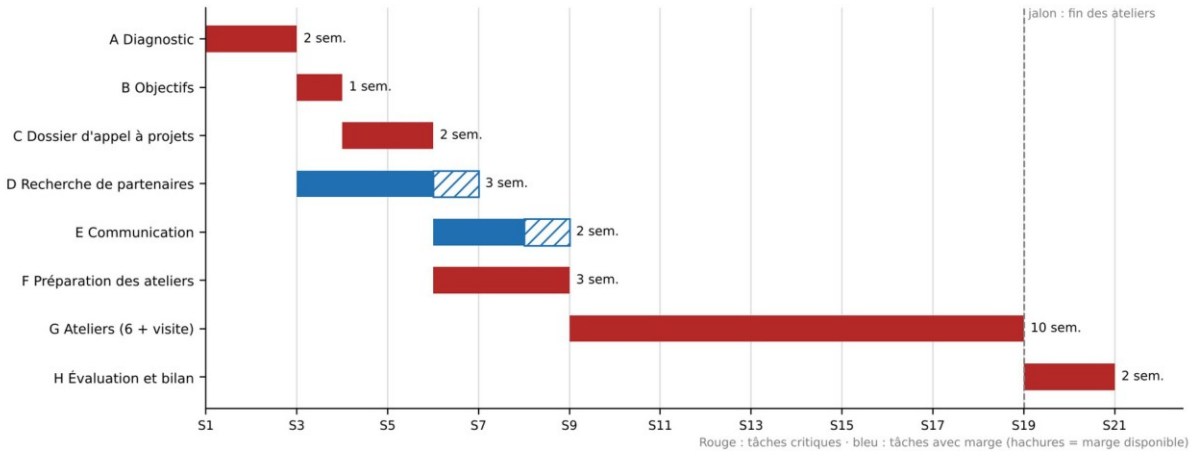


Figure 8.4 – Le diagramme de Gantt correspondant

Comprendre le schéma – Figure 8.4

1. Les tâches **critiques** (en rouge) s'enchaînent sans interruption de la semaine 1 à la semaine 20.

2. Les tâches **D** et **E** (en bleu) disposent d'une **marge** d'une semaine (hachures) : elles peuvent glisser sans retarder le projet.
3. Le **jalon** « fin des ateliers » (fin de la semaine 18) déclenche l'évaluation finale.
4. Dans la réalité, on ajoute les **contraintes de calendrier** : vacances scolaires (pas d'atelier parents-enfants), Ramadan (chapitre 4), dates du stage, date limite de l'appel à projets, disponibilité de la cuisine.

Astuce – Prévoir des marges

Ajoutez une **marge de sécurité** de 10 à 20 % sur les tâches dépendant d'autres personnes (signature de convention, réponse d'un financeur, impression) et fixez le dépôt d'un dossier **quelques jours avant** la date limite. Les délais de versement d'une subvention peuvent dépasser plusieurs mois : vérifiez la **trésorerie** de la structure.

Construire un diagramme de Gantt pas à pas

Le diagramme de Gantt est l'outil de planification le plus utilisé dans les structures, parce qu'il se lit d'un coup d'œil. On peut le construire sur papier quadrillé, dans un tableur (une colonne par semaine, des cellules colorées) ou dans un logiciel de gestion de projet (8.3.14).

Méthode pas à pas – Construire un Gantt en six étapes

1. Lister les tâches à partir du plan d'action, avec un verbe (« réserver la salle », « rédiger les fiches »).

2. Estimer la durée de chaque tâche, en semaines pour un projet de plusieurs mois, en jours pour un événement.

3. Noter les antériorités : quelles tâches doivent être finies avant de commencer celle-ci ?

4. Placer les tâches sur l'échelle de temps, en commençant par celles qui n'ont pas d'antériorité, puis en respectant les dépendances.

5. Ajouter les contraintes de calendrier : vacances, fêtes religieuses, fermeture des locaux, période de stage, date limite d'un appel à projets, disponibilité des partenaires.

6. Placer les jalons (losanges) : décisions du comité de pilotage, dépôt du dossier, premier atelier, fin des ateliers, bilan.

Le rétroplanning : partir de la date imposée

Quand une date est imposée (date limite d'un dossier, date d'un forum, date de l'épreuve), on construit le planning **à rebours** : on part de cette date et on remonte le temps, tâche par tâche, en ajoutant une marge de sécurité. C'est le **rétroplanning**.

Exemple – Rétroplanning d'un stand au forum santé d'une commune (samedi 9 octobre 2027)

Échéance	Tâche	Responsable
Lundi 6 septembre	Valider le thème du stand et le message principal avec la tutrice	Étudiante
Lundi 13 septembre	Réserver le matériel (tables, grilles d'exposition, balance) auprès de la mairie	Tutrice
Vendredi 17 septembre	Concevoir le jeu « quel est le prix au kilo ? » et le tester avec deux collègues	Étudiante
Lundi 20 septembre	Envoyer les fichiers des affiches à l'imprimeur (délai : 10 jours)	Étudiante

Échéance	Tâche	Responsable
Vendredi 1er octobre	Récupérer les affiches ; préparer la liste de courses de la dégustation	Étudiante
Mercredi 6 octobre	Vérifier les inscriptions des bénévoles, imprimer les fiches recettes	Tutrice et étudiante
Vendredi 8 octobre	Courses ; préparation des boîtes de dégustation, stockage au froid	Étudiante et bénévole
Samedi 9 octobre	Forum santé	Équipe

Le rétroplanning montre que le **délai d'impression** (10 jours) commande toute la préparation : si les fichiers partent le 20 septembre, le jeu doit être prêt avant. C'est l'équivalent, en planification à rebours, du chemin critique.

Attention – Un planning se partage et se met à jour

Un Gantt construit au début du projet et jamais relu ne sert à rien. On le met à jour à chaque réunion du comité technique : tâches terminées, retards, nouvelles contraintes. On l'envoie aux partenaires qui ont des tâches à réaliser. Le décalage entre le planning prévu et le planning réel est un indicateur de pilotage (8.3.6).

À vous de jouer – Exercice d'application 8.9

Une association organise une « semaine des légumes secs » dans un restaurant administratif, du lundi 7 au vendredi 11 juin 2027. Elle doit : valider les menus avec le chef (5 jours ouvrés avant la commande) ; commander les denrées (10 jours ouvrés avant la semaine) ; faire imprimer les affiches (7 jours ouvrés de délai) ; afficher une semaine avant. Construisez le rétroplanning en dates, sans compter les week-ends ni le lundi 17 mai 2027 (lundi de Pentecôte, jour non travaillé dans ce restaurant).

Corrigé

Affichage : au plus tard le **lundi 31 mai**. Commande : 10 jours ouvrés avant le lundi 7 juin, soit le **lundi 24 mai** (on compte en arrière : 4, 3, 2, 1 juin, 31 mai, 28, 27, 26, 25, 24 mai). Validation des menus : 5 jours ouvrés avant le 24 mai, en sautant le lundi 17 mai (on compte 21, 20, 19, 18 et 14 mai), soit le **vendredi 14 mai**. Impression : les affiches doivent être prêtes le 31 mai ; 7 jours ouvrés avant : 28, 27, 26, 25, 24, 21 et 20 mai, envoi des fichiers le **jeudi 20 mai**. On prévoit une marge : valider les menus dès le 12 mai et envoyer les fichiers le 18 mai.

Un deuxième réseau PERT : quand une tâche consomme sa marge

Le calcul des dates (8.3.4) ne sert pas seulement à trouver la durée du projet. Il permet surtout de savoir **où porter son attention** quand un incident survient. L'exemple suivant montre qu'une tâche non critique peut devenir critique si elle consomme toute sa marge.

Tâche	Intitulé	Durée (semaines)	Antériorités
A	Accord du lycée professionnel et des familles	2	–
B	Conception des séances avec les enseignants	3	A
C	Choix de l'emplacement du jardin	1	A
D	Fabrication des bacs par la section menuiserie	4	B
E	Rédaction des fiches de culture	2	B, C
F	Achat des plants et du terreau	3	C

Tâche	Intitulé	Durée (semaines)	Antériorités
G	Plantations et première dégustation	2	D, E, F

Exemple – Calcul détaillé : dates, marges et effet d'un retard

Calcul aller. A : 0 → 2. B : 2 → 5. C : 2 → 3. D : 5 → 9. E : début = max(5 ; 3) = 5 → 7. F : 3 → 6. G : début = max(9 ; 7 ; 6) = 9 → **11**. Durée minimale : **11 semaines**.

Calcul retour. G : 9 → 11. D : fin au plus tard 9, début 5. E : fin 9, début 7. F : fin 9, début 6. B : fin = min(début D ; début E) = min(5 ; 7) = 5, début 2. C : fin = min(début E ; début F) = min(7 ; 6) = 6, début 5. A : fin = min(2 ; 5) = 2, début 0.

Marges. A, B, D, G : 0 → chemin critique **A → B → D → G** (2 + 3 + 4 + 2 = 11). C : 5 − 2 = **3 semaines** ; E : 7 − 5 = **2 semaines** ; F : 6 − 3 = **3 semaines**.

Incident. Le fournisseur de plants annonce un délai de 6 semaines au lieu de 3 (F = 6). F commence à 3 et finit à 9 : la fin du projet reste à **11 semaines**, car F avait 3 semaines de marge. Mais F et C deviennent **critiques** : il existe maintenant deux chemins critiques (A → B → D → G et A → C → F → G). Le moindre retard supplémentaire sur le choix de l'emplacement ou sur la livraison retarderait les plantations. L'équipe décide de choisir l'emplacement dès la semaine 2 et de relancer le fournisseur chaque semaine.

Attention – Marge totale et marge partagée

Les marges de tâches qui se suivent ne s'additionnent pas. Dans l'exemple, C et F ont chacune 3 semaines de marge, mais elles sont sur le même chemin : si C prend 3 semaines de retard, F n'a plus aucune marge. On parle de marge **totale** pour la marge calculée tâche par tâche ; elle est partagée par toutes les tâches d'un même chemin.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.10

Reprenez le réseau de l'exemple, avec les durées d'origine. La conception des séances (B) prend 4 semaines au lieu de 3. Calculez la nouvelle durée du projet et indiquez si le chemin critique change.

Corrigé

B est critique : B finit à 2 + 4 = 6 ; D : 6 → 10 ; E : début max(6 ; 3) = 6 → 8 ; G : début max(10 ; 8 ; 6) = 10 → **12 semaines**. Le projet prend une semaine de retard. Le chemin critique reste **A → B → D → G** (2 + 4 + 4 + 2 = 12). Pour rattraper la semaine, on peut demander à la section menuiserie de commencer les bacs dès que les plans sont prêts, sans attendre la fin de la conception des séances.

Estimer une durée incertaine : l'estimation à trois points

Certaines durées sont très incertaines : la réponse d'une mairie, le recrutement de participants, la livraison d'un matériel. Plutôt que de donner un seul chiffre, la méthode PERT d'origine (1958) propose trois estimations : une durée **optimiste** (O, tout se passe bien), une durée **la plus probable** (M) et une durée **pessimiste** (P, tout se passe mal). On en tire une durée attendue et une mesure de l'incertitude.

Définition – Durée attendue et écart-type d'une tâche

Durée attendue = (O + 4 × M + P) / 6. Écart-type ≈ (P − O) / 6. Plus l'écart entre la durée optimiste et la durée pessimiste est grand, plus la tâche est incertaine, et plus il faut la surveiller ou la commencer tôt.

Exemple – Calcul détaillé : trois tâches incertaines d'un projet de jardin partagé

Tâche	O	M	P	Durée attendue	Écart-type
Obtenir l'accord écrit de la mairie	1	3	8	(1 + 12 + 8) / 6 = **3,5** sem.	(8 − 1) / 6 = **1,17** sem.
Aménager les parcelles	2	3	4	(2 + 12 + 4) / 6 = **3,0** sem.	(4 − 2) / 6 = **0,33** sem.
Recruter 12 familles jardinières	1	2	5	(1 + 8 + 5) / 6 = **2,33** sem.	(5 − 1) / 6 = **0,67** sem.

Si les trois tâches se suivent, la durée attendue est 3,5 + 3,0 + 2,33 = **8,83 semaines**. L'accord de la mairie est la tâche la plus incertaine (écart-type de 1,17 semaine) : c'est elle qu'il faut lancer le plus tôt possible et relancer. Pour fixer une date d'ouverture prudente, on ajoute une marge : environ deux écarts-types sur l'ensemble du chemin (calcul simplifié : $\sqrt{(1{,}17^2 + 0{,}33^2 + 0{,}67^2)} \approx 1{,}38$ semaine), soit 8,83 + 2 × 1,38 ≈ **11,6 semaines**, arrondies à 12 semaines. C'est un ordre de grandeur, pas une certitude.

Astuce – Demander les trois durées aux bonnes personnes

Les durées optimiste, probable et pessimiste se demandent à ceux qui connaissent le terrain : la secrétaire de mairie pour un accord, l'imprimeur pour une impression, l'animatrice pour un recrutement. Leur expérience vaut mieux qu'une estimation au hasard, et la question les implique dans le projet.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.11

L'impression d'un livret de recettes demande 1 semaine au mieux, 2 semaines le plus souvent et 5 semaines au pire (relectures, corrections). Calculez la durée attendue et l'écart-type, puis dites combien de semaines vous prévoyez dans le planning, et pourquoi.

Corrigé

Durée attendue : (1 + 4 × 2 + 5) / 6 = 14 / 6 = **2,33 semaines**. Écart-type : (5 − 1) / 6 = **0,67 semaine**. On peut prévoir 2,33 + 2 × 0,67 ≈ **3,7 semaines**, soit environ 4 semaines, car le livret doit être prêt pour une date fixe (dernier atelier) et le risque de retard vient surtout des relectures, que l'on peut anticiper en les programmant tôt.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.4 – La planification

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qu'un jalon dans un diagramme de Gantt ?
2. Dans le calcul aller du PERT, prend-on le maximum ou le minimum des fins des tâches précédentes ? Pourquoi ?
3. Comment calcule-t-on la marge d'une tâche ?
4. Qu'est-ce que le chemin critique ?
5. Une tâche a 2 semaines de marge et prend 3 semaines de retard. De combien le projet est-il retardé ?
6. Donnez la formule de la durée attendue dans l'estimation à trois points.

Corrigé – Point d'étape 8.3.4

1. Une date clé (décision, dépôt, début ou fin d'une phase), représentée par un losange.
2. Le maximum : une tâche ne peut commencer que lorsque toutes les tâches qui la précèdent sont finies.
3. Marge = début au plus tard − début au plus tôt.
4. La suite des tâches dont la marge est nulle ; sa durée est la durée minimale du projet.
5. D'une semaine (3 − 2), si aucune autre tâche ne change.

6. (O + 4 × M + P) / 6.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 8.3.5.
3 ou 4 sur 6	Je refais le calcul détaillé du réseau PERT.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 8.3.4 et je refais les exercices d'application.

8.3.5 Construire et suivre le budget

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

La structure d'un budget prévisionnel

Le budget prévisionnel d'un projet associatif suit le **plan comptable associatif** simplifié (formulaire Cerfa n° 12156) : il est présenté en **charges** (dépenses) et **produits** (ressources), et il doit être **équilibré** (total des charges = total des produits).

Compte	Charges	Exemples
60	Achats	Denrées, petit matériel, fournitures pédagogiques
61-62	Services extérieurs et autres services	Location, assurance, impression, déplacements, honoraires d'intervenants extérieurs
63	Impôts et taxes	Taxes sur salaires (rare pour un petit projet)
64	Charges de personnel	Salaires et charges des salariés affectés au projet (au prorata du temps)
86	Emplois des contributions volontaires en nature	Bénévolat, mise à disposition de locaux, dons de produits (valorisés)
Compte	Produits	Exemples
70	Ventes, prestations	Participation des usagers
74	Subventions d'exploitation	ARS (FIR), commune, département, CAF, fondations
75	Autres produits de gestion courante	Cotisations, dons
87	Contributions volontaires en nature	Contrepartie exacte du compte 86

Attention – Les règles d'or du budget

1. Équilibre : charges = produits ; l'autofinancement du porteur comble l'écart.

2. Comptes 86 = 87 : les contributions en nature apparaissent des deux côtés, pour le même montant.

3. Cofinancement : un financeur ne finance presque jamais 100 % ; montrer la diversité des ressources.

4. Cohérence : chaque ligne correspond à une action décrite (pas de « divers » important).

5. Justification : quantité × coût unitaire, avec des prix réalistes (devis, relevés de prix).

6. Prudence : distinguer les financements **acquis** et **sollicités**.

Exemple – Calcul détaillé : coût horaire d'une salariée affectée au projet

Une référente familles est rémunérée **2 000 € bruts par mois** ; les charges patronales représentent environ **42 %** du brut (ordre de grandeur à vérifier auprès de la structure ; il varie selon les allègements de cotisations).

- Coût employeur mensuel : 2 000 × 1,42 = **2 840 €**.

- Heures mensuelles (35 h par semaine) : 35 × 52 / 12 = **151,67 h**.
- Coût horaire : 2 840 / 151,67 = **18,73 €**.
- Temps affecté au projet : 30 h → 30 × 18,73 = **561,90 €** à inscrire au compte 64.

Dans le budget des Tilleuls (chapitre 1), la ligne « coordinatrice » a été valorisée à 24 € de l'heure, taux communiqué par la structure (il intègre une quote-part de frais de structure) : on utilise **toujours** le taux fourni par l'employeur et on le précise.

Le budget du projet des Tilleuls : ratios d'analyse

Rappel (fiche F6, chapitre 1) : charges totales **3 510 €**, dont personnel 1 520 + 720 = 2 240 € ; subvention ARS **1 500** € ; commune 600 € ; CAF 400 € ; participation des familles 144 € ; contributions en nature 450 € ; autofinancement 416 €.

Ratio	Calcul	Résultat
Part de la subvention ARS	1 500 / 3 510 × 100	42,7 %
Part des financements publics	(1 500 + 600 + 400) / 3 510 × 100 = 2 500 / 3 510 × 100	71,2 %
Part du personnel	2 240 / 3 510 × 100	63,8 %
Coût par famille	3 510 / 12	292,50 €
Coût par heure d'atelier	3 510 / (6 × 3 h) = 3 510 / 18	195,00 €
Part des contributions en nature	450 / 3 510 × 100	12,8 %
Participation des familles par rapport au coût par famille	12 / 292,50 × 100 (12 € = 2 € × 6 ateliers)	4,1 %

Interprétation : le projet est majoritairement financé par des fonds publics et repose surtout sur du **temps humain**, ce qui est habituel en éducation pour la santé ; la participation symbolique des familles (2 € par atelier) favorise l'engagement sans exclure ; le coût par famille (292,50 €) se justifie par l'intensité de l'accompagnement (6 ateliers de 3 heures, livret, visite).

Suivre le budget réalisé

Exemple – Calcul détaillé : écarts entre budget prévisionnel et réalisé

Poste	Prévu	Réalisé	Écart (€)	Écart (%)
Denrées	210,00	236,40	+ 26,40	+ 12,6 %
Petit matériel	180,00	172,50	− 7,50	− 4,2 %
Supports pédagogiques	150,00	150,00	0,00	0,0 %
Impression, communication	220,00	198,00	− 22,00	− 10,0 %
Déplacements	60,00	48,00	− 12,00	− 20,0 %
Diététicienne	1 520,00	1 520,00	0,00	0,0 %
Coordinatrice (32 h × 24 €)	720,00	768,00	+ 48,00	+ 6,7 %
Locaux (valorisation)	210,00	210,00	0,00	0,0 %
Bénévolat (24 h × 12 €)	240,00	288,00	+ 48,00	+ 20,0 %
Total	3 510,00	3 590,90	+ 80,90	+ 2,3 %

Formules : écart (€) = réalisé − prévu ; écart (%) = écart / prévu × 100. Exemple : denrées : 236,40 − 210,00 = 26,40 € ; 26,40 / 210,00 × 100 = **12,6 %**. **Total réalisé** : 236,40 + 172,50 + 150 + 198 + 48 + 1 520 + 768 + 210 + 288 = **3 590,90 €** ; écart : 3 590,90 − 3 510 = **80,90 €**, soit 80,90 / 3 510 × 100 = **2,3 %**. **Analyse** : le dépassement des denrées s'explique par la hausse des prix des fruits (+ 12,6 %) ; il est compensé en partie par

les économies d'impression (impression au centre social) et de déplacements (covoiturage) ; le bénévolat supplémentaire (+ 4 h de mamans relais) est une bonne nouvelle (participation) et ne coûte rien en trésorerie (il est valorisé aux comptes 86 et 87 : les produits en nature passent aussi à 210 + 288 = 498 €). L'écart réel de trésorerie est donc : 26,40 − 7,50 − 22 − 12 + 48 = **+ 32,90 €**, couvert par l'autofinancement. Un écart global inférieur à 5 % est généralement jugé satisfaisant ; les écarts importants sur un poste sont **expliqués** dans le compte rendu financier.

Valoriser les contributions volontaires en nature

Un projet de prévention mobilise souvent des ressources qui ne coûtent rien à la structure : du temps de bénévoles, une salle prêtée, des denrées données, du matériel mis à disposition. Ces **contributions volontaires en nature** ont pourtant une valeur. Les inscrire au budget montre le vrai coût du projet, l'engagement du territoire et, souvent, la capacité du porteur à mobiliser des partenaires. Le plan comptable des associations (règlement ANC n° 2018-06) prévoit de les présenter dans les comptes 86 (emplois) et 87 (contributions), ou de les décrire dans l'annexe des comptes.

Contribution	Méthode de valorisation	Justificatif
Bénévolat	Nombre d'heures × taux horaire choisi par la structure et justifié (souvent le coût d'un salarié qui ferait la même tâche)	Feuille de présence ou de temps des bénévoles
Mise à disposition d'une salle	Nombre d'heures ou de demi-journées × tarif de location pratiqué par le propriétaire	Attestation du propriétaire, grille tarifaire
Don de denrées ou de matériel	Valeur de marché (prix d'achat équivalent)	Attestation du donateur, bon de livraison
Personnel mis à disposition par un partenaire	Heures × coût horaire communiqué par l'employeur	Attestation de l'employeur

Exemple – Calcul détaillé : les contributions en nature d'un projet de repas partagés

Trois bénévoles donnent chacun 40 heures sur l'année ; l'association a fixé un taux de 14 € de l'heure (taux fictif, expliqué dans l'annexe). La mairie prête une salle pour 12 demi-journées, qu'elle loue habituellement 25 € la demi-journée. Un primeur donne des légumes d'une valeur de 150 €.

- Bénévolat : 3 × 40 × 14 = **1 680 €**.
- Salle : 12 × 25 = **300 €**.
- Denrées données : **150 €**.
- Total : 1 680 + 300 + 150 = **2 130 €**, inscrits au compte 86 (charges) et au compte 87 (produits).

Le budget reste équilibré : les contributions en nature apparaissent pour le même montant des deux côtés. Elles n'entrent pas dans le plan de trésorerie, puisqu'aucun argent ne circule.

Attention – Ne pas gonfler les valorisations

Une valorisation exagérée (un taux horaire très élevé pour du bénévolat, une salle comptée au prix d'un hôtel) fait perdre sa crédibilité au dossier. Le taux doit être justifié, cohérent d'une année sur l'autre, et appuyé sur des pièces. Certains financeurs excluent les contributions en nature du calcul de leur subvention ou du cofinancement : il faut le vérifier dans le cahier des charges (8.3.3).

À vous de jouer – Exercice d'application 8.12

Une association organise 8 ateliers. Deux bénévoles sont présents à chaque atelier pendant 3 heures (taux retenu : 13 € de l'heure). Un supermarché donne des fruits pour une valeur de 20 € par atelier. Le centre

social prête sa cuisine, qu'il loue 30 € l'atelier. Calculez le montant des contributions en nature et indiquez comment elles apparaissent dans le budget.

Corrigé

Bénévolat : 2 × 8 × 3 × 13 = **624 €** ; fruits : 8 × 20 = **160 €** ; cuisine : 8 × 30 = **240 €** ; total : 624 + 160 + 240 = **1 024 €**. Ce montant apparaît au **compte 86** (emplois des contributions volontaires en nature, côté charges) et au **compte 87** (contributions volontaires en nature, côté produits), avec le détail des trois lignes. Il ne figure pas dans le plan de trésorerie.

Construire un budget prévisionnel pas à pas

Un budget se construit à partir du plan d'action, ligne par ligne, et jamais en partant du montant que l'on espère obtenir. Chaque ligne s'écrit sous la forme **quantité × coût unitaire**, avec la source du coût (devis, tarif, relevé de prix, taux communiqué par l'employeur).

Méthode pas à pas – Construire le budget en sept étapes

1. Lister les moyens nécessaires à chaque action (fiches QQOQCCP, rubrique « combien ? »).

2. Chiffrer chaque moyen : quantité × coût unitaire, avec sa source.

3. Classer les charges dans les comptes (60, 61, 62, 63, 64) et ajouter les contributions en nature (86).

4. Additionner les charges monétaires, les contributions en nature et le total.

5. Inscrire les produits connus : subventions acquises et sollicitées, participation, mécénat, contributions en nature (87, même montant que le compte 86).

6. Calculer l'autofinancement qui équilibre le budget, et vérifier qu'il est supportable pour la structure.

7. Vérifier : total des charges = total des produits ; 86 = 87 ; règles des financeurs (plafond, taux, cofinancement) ; cohérence avec le plan d'action.

Exemple – Calcul détaillé : le budget du projet « Cuisine en pied d'immeuble » d'une régie de quartier (fictif)

Le projet comprend 10 ateliers de 3 heures pour 10 habitants, animés par une animatrice salariée et une diététicienne libérale.

- 60 – Denrées : 10 ateliers × 28 € = **280,00 €** (relevé de prix de deux magasins).
- 60 – Petit matériel : **240,00 €** (devis).
- 61 – Assurance complémentaire de l'activité : **60,00 €**.
- 62 – Impression des fiches et des affiches : **120,00 €** (devis de l'imprimeur).
- 62 – Honoraires de la diététicienne : 10 × 2,5 h × 50 € = **1 250,00 €**.
- 62 – Déplacements : 216 km × 0,40 € (taux fixé par la régie) = **86,40 €**.
- 64 – Animatrice : 70 h × 19,20 € (coût horaire chargé communiqué par la régie) = **1 344,00 €**.
- 86 – Bénévolat : 2 bénévoles × 10 ateliers × 3 h × 13 € = **780,00 €** ; 86 – Salle prêtée : 10 × 3 h × 20 € = **600,00 €**.

Charges monétaires : 280 + 240 + 60 + 120 + 1 250 + 86,40 + 1 344 = **3 380,40 €** ; contributions en nature : 780 + 600 = **1 380,00 €** ; total : **4 760,40 €**.

Produits	Montant	Statut
74 – Commune	1 500,00 €	Acquis
74 – Département	1 000,00 €	Sollicité
75 – Mécénat du bailleur social	600,00 €	Acquis

Produits	Montant	Statut
70 – Participation des habitants (1 € × 10 × 10)	100,00 €	Prévu
Autofinancement de la régie	180,40 €	Acquis
87 – Contributions volontaires en nature	1 380,00 €	Prévu
Total	**4 760,40 €**	

Autofinancement : 3 380,40 − (1 500 + 1 000 + 600 + 100) = **180,40 €**, soit 5,3 % des charges monétaires. Les financements publics représentent 2 500 / 4 760,40 × 100 = **52,5 %** du budget total. Si le département refuse, il manquera 1 000 € : la régie a prévu une version à six ateliers.

Astuce – Prévoir une version réduite

Quand un financement important est seulement sollicité, préparez dès le départ une version réduite du projet (moins d'ateliers, moins d'heures de diététicienne) et calculez son budget. Si la réponse est négative ou partielle, vous savez immédiatement ce que vous pouvez maintenir, et vous le présentez au comité de pilotage.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.13

Dans l'exemple, le département n'accorde que 600 € au lieu de 1 000 €. La régie décide de supprimer deux ateliers. Chaque atelier supprimé économise 28 € de denrées, 125 € d'honoraires et 7 heures d'animatrice ; la participation diminue de 10 € par atelier. Les autres charges ne changent pas. Calculez les nouvelles charges monétaires et le nouvel autofinancement.

Corrigé

Économie par atelier : 28 + 125 + 7 × 19,20 = 28 + 125 + 134,40 = **287,40 €** ; pour deux ateliers : **574,80 €**. Nouvelles charges monétaires : 3 380,40 − 574,80 = **2 805,60 €**. Produits monétaires hors autofinancement : 1 500 + 600 + 600 + (100 − 20) = **2 780,00 €**. Autofinancement : 2 805,60 − 2 780,00 = **25,60 €**. (Les contributions en nature baissent aussi si les bénévoles et la salle ne sont plus mobilisés pour ces deux ateliers ; les comptes 86 et 87 restent égaux.)

Coûts fixes, coûts variables et nombre minimal de participants

Certaines charges ne dépendent pas du nombre de participants : l'animatrice est payée pour l'atelier, que le groupe compte 5 ou 12 personnes. Ce sont des **coûts fixes**. D'autres augmentent avec chaque participant : les denrées, les fiches remises, parfois le transport. Ce sont des **coûts variables**. Distinguer les deux permet de calculer le **coût par participant** et le **nombre minimal de participants** pour qu'une action financée « à la personne » couvre ses coûts.

Définition – Coût par participant et seuil

Coût par participant = coûts fixes / nombre de participants + coût variable par participant. Quand chaque participant rapporte une recette R (forfait d'un financeur, participation), le **seuil** est le nombre de participants à partir duquel les recettes couvrent les coûts : seuil = coûts fixes / (R − coût variable par participant), arrondi à l'unité supérieure.

Exemple – Calcul détaillé : un atelier « cuisine et mémoire » financé à la personne

Coûts fixes d'un atelier : diététicienne 2 h × 55 € = 110,00 € ; animatrice 3 h × 19,20 € = 57,60 € ; salle 25,00

€ ; total **192,60 €**. Coûts variables : denrées 1,90 € et fiche 0,30 €, soit **2,20 €** par participant. Une caisse de retraite (fictive) verse 16 € par participant présent, et chaque participant paie 2 € : recette **18 €** par participant.

Participants	Coût par participant	Résultat de l'atelier
5	192,60 / 5 + 2,20 = 40,72 €	5 × 18 − (192,60 + 5 × 2,20) = − 113,60 €
8	192,60 / 8 + 2,20 = 26,28 €	− 66,20 €
10	21,46 €	− 34,60 €
12	18,25 €	− 3,00 €
15	15,04 €	+ 44,40 €

Seuil : 192,60 / (18 − 2,20) = 192,60 / 15,80 = **12,2**, soit **13 participants**. Avec une salle de 12 places, l'atelier ne peut pas couvrir ses coûts : il faut réduire les coûts fixes (salle prêtée gratuitement : seuil = 167,60 / 15,80 = 10,6, soit 11 participants) ou obtenir un autre financement.

Attention – Le seuil n'est pas un objectif pédagogique

Un atelier de 15 personnes couvre mieux ses coûts qu'un atelier de 8, mais il n'est pas forcément meilleur : chacun cuisine moins, l'animatrice accompagne moins. Le calcul du seuil éclaire une décision ; il ne la remplace pas. On cherche un équilibre entre la qualité de l'atelier, l'équité d'accès et la viabilité financière.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.14

Un atelier coûte 150 € de coûts fixes et 3 € de denrées par participant. Un financeur verse 15 € par participant. Calculez le coût par participant pour 8 et pour 12 participants, puis le seuil.

Corrigé

8 participants : 150 / 8 + 3 = 18,75 + 3 = **21,75 €**. 12 participants : 150 / 12 + 3 = 12,50 + 3 = **15,50 €**. Seuil : 150 / (15 − 3) = 150 / 12 = **12,5**, soit **13 participants**. Avec 12 participants, il manque 12 × 15 − (150 + 12 × 3) = 180 − 186 = **6 €** par atelier.

Acheter : comparer des devis avec une grille pondérée

Les achats importants du projet (matériel de cuisine, impression, transport) se font sur **devis**. La plupart des structures fixent une règle interne : au-delà d'un certain montant, on demande au moins **trois devis** et l'on garde une trace du choix. Le moins cher n'est pas toujours le meilleur : on compare les devis avec une **grille pondérée**, comme pour hiérarchiser des priorités (chapitre 7).

Méthode – Comparer des devis en cinq étapes

1. Rédiger un **besoin précis** et le même pour tous les fournisseurs (quantités, caractéristiques, délai, livraison).
2. Choisir les **critères** (prix, délai, qualité, service après-vente, proximité, engagement social ou environnemental) et leur **poids**, avant de lire les devis.
3. **Noter** chaque devis sur 10 pour chaque critère.
4. Calculer la **note pondérée** : somme des notes multipliées par les poids.
5. **Conserver** la grille et les devis : ils justifient la dépense auprès du financeur et de la direction.

Exemple – Calcul détaillé : le choix d'un fournisseur de matériel de cuisine (données fictives)

Besoin : 4 plaques à induction mobiles, 4 lots de casseroles compatibles, 2 balances, livraison avant le 15 septembre. Poids des critères : prix 40 %, délai 20 %, qualité 30 %, service après-vente 10 %.

Critère (poids)	Fournisseur 1	Fournisseur 2	Fournisseur 3
Prix (0,4)	8	10	6
Délai (0,2)	6	8	9
Qualité (0,3)	7	5	9
Service après-vente (0,1)	9	5	8
Note pondérée	7,4	7,6	7,7

- Fournisseur 1 : 0,4 × 8 + 0,2 × 6 + 0,3 × 7 + 0,1 × 9 = 3,2 + 1,2 + 2,1 + 0,9 = **7,4**.
- Fournisseur 2 : 0,4 × 10 + 0,2 × 8 + 0,3 × 5 + 0,1 × 5 = 4,0 + 1,6 + 1,5 + 0,5 = **7,6**.
- Fournisseur 3 : 0,4 × 6 + 0,2 × 9 + 0,3 × 9 + 0,1 × 8 = 2,4 + 1,8 + 2,7 + 0,8 = **7,7**.

Décision : le fournisseur 3, le plus cher, obtient la meilleure note grâce à sa qualité et à son délai. L'écart avec le fournisseur 2 est faible (0,1 point) : on vérifie que le budget permet ce choix, et l'on peut demander au fournisseur 3 s'il accepte une remise. Si le budget est trop juste, le fournisseur 2 reste un choix défendable.

Attention – Fixer les poids avant d'ouvrir les devis

Si l'on choisit les poids après avoir lu les devis, on risque, même sans le vouloir, de les ajuster pour favoriser un fournisseur. La grille doit être décidée à l'avance, si possible avec une autre personne (tutrice, trésorier de l'association).

À vous de jouer – Exercice d'application 8.15

Reprenez la grille ci-dessus en changeant les poids : prix 60 %, délai 10 %, qualité 20 %, service 10 %. Recalculez les notes pondérées et indiquez le fournisseur retenu. Que montre cet exercice ?

Corrigé

Fournisseur 1 : 0,6 × 8 + 0,1 × 6 + 0,2 × 7 + 0,1 × 9 = 4,8 + 0,6 + 1,4 + 0,9 = 7,7. Fournisseur 2 : 0,6 × 10 + 0,1 × 8 + 0,2 × 5 + 0,1 × 5 = 6,0 + 0,8 + 1,0 + 0,5 = 8,3. Fournisseur 3 : 0,6 × 6 + 0,1 × 9 + 0,2 × 9 + 0,1 × 8 = 3,6 + 0,9 + 1,8 + 0,8 = 7,1. Le fournisseur 2 est retenu. L'exercice montre que le résultat dépend fortement des poids : c'est pourquoi on les fixe avant de lire les devis et on les justifie (par exemple, un budget très contraint justifie un poids élevé pour le prix).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.5 – Le budget

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans quel compte inscrit-on les honoraires d'une diététicienne libérale ? Le salaire d'une animatrice ?
2. Pourquoi les comptes 86 et 87 doivent-ils être égaux ?
3. Calculez le coût horaire d'une salariée dont le coût employeur mensuel est de 2 730 € pour 151,67 heures.
4. Un poste prévu à 250 € est réalisé à 280 €. Calculez l'écart en euros et en pourcentage.
5. Comment valorise-t-on une salle prêtée gratuitement ?
6. Qu'est-ce qu'un coût fixe ? Donnez un exemple dans un atelier culinaire.

Corrigé – Point d'étape 8.3.5

1. Honoraires : compte 62 ; salaire et charges : compte 64.

2. Ce sont les deux faces d'une même contribution : on l'utilise (86, charge) et on la reçoit (87, produit) ; leur égalité garde le budget équilibré.

3. 2 730 / 151,67 = **18,00 €** de l'heure.

4. 280 − 250 = **+ 30 €** ; 30 / 250 × 100 = **+ 12,0 %**.

5. Nombre d'heures ou de demi-journées × tarif de location pratiqué par le propriétaire, avec une attestation.

6. Une charge qui ne dépend pas du nombre de participants, par exemple le temps de l'animatrice ou la location de la salle.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 8.3.6.
3 ou 4 sur 6	Je refais le budget pas à pas de la régie de quartier.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 8.3.5 et je refais les exercices d'application.

8.3.6 Piloter le projet

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Définition – Pilotage

Ensemble des activités qui permettent de **suivre** l'avancement du projet (activités, délais, budget, participation), de **repérer** les écarts et les risques, de **décider** des ajustements et d'en **rendre compte** aux partenaires et financeurs.

Le tableau de bord de suivi

Indicateur de suivi	Prévu à mi-parcours	Réalisé à mi-parcours	Analyse
Ateliers réalisés	3 / 6	3 / 6	Conforme
Taux de présence	≥ 80 %	31 / 36 = 86,1 %	Conforme
Familles inscrites	12	12 (dont 1 remplacement)	Liste d'attente utilisée
Budget consommé	≈ 50 %	1 650 / 3 510 = 47,0 %	Conforme
Questionnaires « avant » recueillis	12	12	Conforme
Supports validés	6 fiches recettes	4	Retard : 2 fiches en relecture FALC

Calcul du taux de présence : 3 ateliers × 12 familles = 36 présences possibles ; 31 présences constatées (11 + 10 +

10. ; 31 / 36 × 100 = **86,1 %** (objectif ≥ 80 % atteint).

Gérer les risques

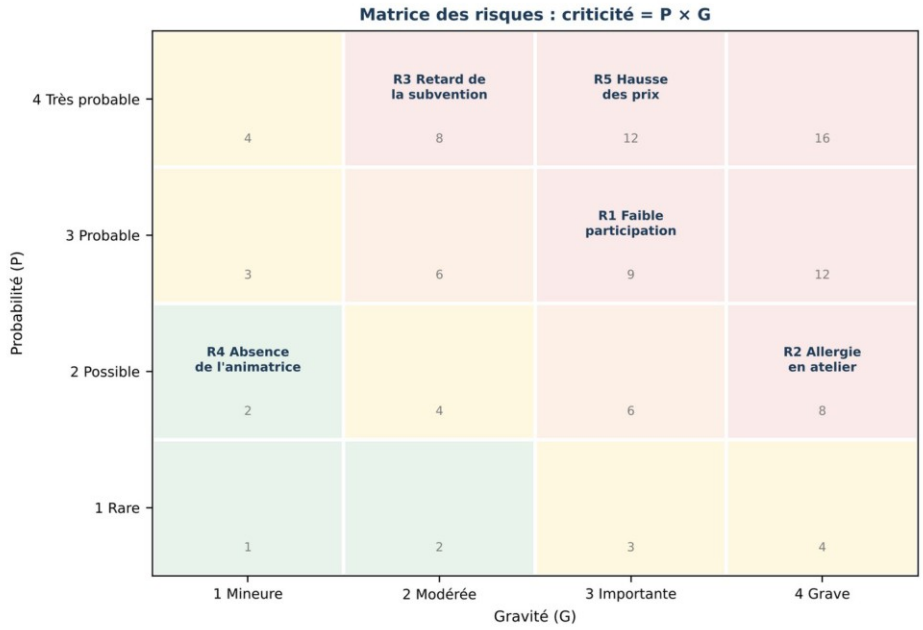


Figure 8.5 – La matrice des risques du projet des Tilleuls

Risque	P	G	P × G	Mesure de prévention ou de réduction
R1 – Faible participation	3	3	9	Inscription en face à face, rappel la veille (SMS, message vocal), horaires adaptés, garde d'enfants, liste d'attente
R2 – Réaction allergique en atelier	2	4	8	Recueil des allergies à l'inscription, étiquetage des 14 allergènes, variantes, trousse et protocole d'urgence
R3 – Retard de versement de la subvention	4	2	8	Vérifier la trésorerie, avance de la structure, achats échelonnés
R4 – Absence de l'animatrice	2	1	2	Conducteurs rédigés et partagés, binôme de remplacement
R5 – Hausse des prix des denrées	4	3	12	Recettes de saison, achats groupés, partenariat avec l'épicerie, marge de 10 % sur la ligne denrées

Lecture : la criticité (P × G, de 1 à 16) classe les risques : R5 (12), puis R1 (9), puis R2 et R3 (8). Un risque de gravité 4 (R2) appelle toujours des mesures, même si sa probabilité est faible.

Animer une réunion et en rendre compte

Méthode pas à pas – Réunion de pilotage efficace

Avant : ordre du jour envoyé une semaine avant, documents joints (tableau de bord, budget). **Pendant** : rappel des objectifs, point d'avancement (ce qui est fait, écarts, risques), décisions à prendre, répartition des tâches (qui fait quoi pour quand), date de la prochaine réunion ; respect du temps. **Après** : **compte rendu** sous 48 heures : présents et excusés, points abordés, **décisions** prises, **relevé des actions** (tâche, responsable, échéance).

Choisir et définir les indicateurs de suivi

Le tableau de bord ne contient pas tous les chiffres possibles : il en retient **quelques-uns**, choisis parce qu'ils permettent de décider. On distingue les indicateurs de **suivi** (ou de processus), qui disent si le projet se déroule comme prévu (activités réalisées, présence, budget, délais), et les indicateurs de **résultat**, qui disent si les objectifs sont atteints. Les premiers servent au pilotage en cours de route ; les seconds servent surtout à l'évaluation (chapitre 9). Un bon tableau de bord compte cinq à huit indicateurs.

Domaine	Indicateur de suivi	Formule	Fréquence
Activité	Taux de réalisation des ateliers	Ateliers réalisés / ateliers prévus à cette date × 100	Chaque mois
Participation	Taux de présence	Présences constatées / présences possibles × 100	Après chaque atelier
Participation	Taux de fidélisation	Participants présents à au moins 4 ateliers sur 6 / inscrits × 100	À mi-parcours et à la fin
Budget	Taux de consommation du budget	Dépenses réalisées / budget prévu × 100	Chaque mois
Délais	Nombre de tâches en retard	Tâches non terminées à leur échéance	À chaque comité technique
Partenariat	Orientations par les partenaires	Nombre de personnes orientées par chaque partenaire	Chaque mois

Définition – Fiche indicateur

Document court qui définit un indicateur pour que tout le monde le calcule de la même façon : **nom**, **définition**, **formule** (numérateur et dénominateur), **source** des données, **fréquence** de mesure, **responsable**, **valeur cible** et **seuil d'alerte** (valeur à partir de laquelle on réagit).

Exemple – Fiche indicateur « taux de présence »

Nom : taux de présence aux ateliers. **Définition** : part des places réservées effectivement occupées. **Formule** : nombre de présences constatées sur les feuilles d'émargement / (nombre d'inscrits × nombre d'ateliers réalisés) × 100. **Source** : feuilles d'émargement. **Fréquence** : après chaque atelier, cumul mensuel. **Responsable** : l'animatrice. **Valeur cible** : 80 % au moins. **Seuil d'alerte** : moins de 70 % sur deux ateliers consécutifs, ce qui déclenche des appels aux personnes absentes et un point au comité technique.

Attention – Un taux sans effectif ne dit rien

Un taux de présence de 50 % peut correspondre à 3 personnes sur 6 ou à 30 personnes sur 60. Dans le tableau de bord, on donne toujours le **nombre** et le **pourcentage**. Pour les petits groupes, une seule absence change fortement le taux : on regarde la tendance sur plusieurs ateliers plutôt qu'une valeur isolée.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.16

Rédigez la fiche indicateur du « taux de consommation du budget » d'un projet de 4 000 €, suivi chaque mois par la coordinatrice. Proposez une valeur cible à mi-parcours et un seuil d'alerte.

Corrigé

Nom : taux de consommation du budget. Définition : part du budget prévisionnel déjà dépensée. Formule : dépenses réalisées (factures et salaires imputés au projet) / 4 000 € × 100. Source : tableau de suivi budgétaire tenu dans le tableur, rapproché des factures. Fréquence : chaque mois. Responsable : la coordinatrice. Valeur cible : proche de l'avancement du projet (environ 50 % à mi-parcours). Seuil d'alerte : un écart de plus de 15 points avec l'avancement (moins de 35 % ou plus de 65 % à mi-parcours), qui conduit à analyser les postes concernés.

Analyser un écart et décider

Un écart entre le prévu et le réalisé n'est pas une faute : c'est une **information**. Le pilotage consiste à le repérer tôt, à en comprendre la cause et à décider d'un ajustement, puis à vérifier que l'ajustement a eu l'effet attendu.

Méthode pas à pas – De l'écart à la décision

1. Constater : quel indicateur, quel écart, depuis quand ? On donne les chiffres.

2. Chercher les causes : on interroge les personnes concernées (participants, animateurs, partenaires) et on vérifie les faits. On peut se demander plusieurs fois « pourquoi ? » pour remonter à la cause profonde.

3. Lister les options : continuer sans changer, ajuster (horaire, lieu, méthode, budget), renforcer (rappels, relais), ou modifier le projet (après accord du financeur).

4. Décider en comité technique ou en comité de pilotage, selon l'importance, et noter la décision (qui fait quoi, pour quand).

5. Vérifier l'effet au point suivant du tableau de bord.

Exemple – Calcul détaillé : une présence qui baisse

Un cycle de six ateliers accueille 12 inscrits. Présences aux quatre premiers ateliers : 11, 10, 8 et 6.

- Taux par atelier : 11 / 12 = **91,7 %** ; 10 / 12 = **83,3 %** ; 8 / 12 = **66,7 %** ; 6 / 12 = **50,0 %**.
- Taux cumulé : (11 + 10 + 8 + 6) / (4 × 12) = 35 / 48 = **72,9 %**, sous la cible de 80 %.
- Évolution entre le premier et le quatrième atelier : (6 − 11) / 11 × 100 = **− 45,5 %**.

Causes recherchées : l'animatrice appelle les six absents. Quatre expliquent que les ateliers 3 et 4 ont eu lieu pendant les vacances scolaires, avec les enfants à la maison ; deux ont repris un travail. **Options** : proposer un accueil des enfants pendant les vacances, ou décaler les deux derniers ateliers hors vacances ; envoyer les fiches recettes aux personnes qui travaillent. **Décision** du comité technique : les ateliers 5 et 6 sont placés hors vacances, avec un rappel par message vocal la veille ; les fiches sont envoyées aux deux personnes en emploi. **Vérification** : 10 et 11 présents aux ateliers 5 et 6 (taux cumulé final : 56 / 72 = 77,8 %).

Astuce – Écrire « on a appris » plutôt que « on a échoué »

Dans le compte rendu et devant le jury, un écart bien analysé est un point fort. La phrase « la présence a baissé pendant les vacances scolaires ; nous avons déplacé les ateliers et elle est remontée » montre une démarche de pilotage. Le jury attend cette capacité d'ajustement plus qu'un projet sans incident.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.17

Un groupe de 10 inscrits a eu les présences suivantes sur cinq ateliers : 9, 9, 7, 8, 6. Calculez le taux de présence de chaque atelier et le taux cumulé, puis proposez deux questions à poser aux personnes absentes au cinquième atelier.

Corrigé

Taux : 90,0 % ; 90,0 % ; 70,0 % ; 80,0 % ; 60,0 %. Taux cumulé : (9 + 9 + 7 + 8 + 6) / (5 × 10) = 39 / 50 = **78,0 %**. Questions : « Qu'est-ce qui vous a empêché de venir cette fois ? » ; « Qu'est-ce qui vous aiderait à venir au prochain atelier (horaire, lieu, garde d'enfants, rappel) ? ». On pose ces questions avec bienveillance, sans reproche, et on note les réponses de façon anonyme pour le comité technique.

Le registre des risques et le plan de repli

La matrice des risques (8.3.6) classe les risques par criticité. Le **registre des risques** va plus loin : pour chaque risque, il nomme un responsable, un **signal d'alerte** qui montre que le risque est en train de se produire, des mesures de **prévention** (pour qu'il n'arrive pas) et un **plan de repli** (ce que l'on fait s'il arrive quand même). On le relit à chaque comité technique.

Risque	Criticité (P × G)	Signal d'alerte	Prévention	Plan de repli	Responsable
Canicule le jour d'un atelier de cuisine	3 × 3 = 9	Alerte de Météo-France à J − 2	Atelier le matin ; recette sans four ; eau fraîche disponible	Remplacer la cuisson par une recette crue ; décaler l'atelier	Animatrice
Absence de la diététicienne	2 × 3 = 6	Message la veille ou le matin	Conducteur écrit et partagé ; binôme formé	L'animatrice assure un atelier « recettes déjà testées »	Coordinatrice
Intoxication alimentaire	1 × 4 = 4	Symptômes signalés après l'atelier	Bonnes pratiques d'hygiène, températures, traçabilité des produits	Conserver les restes et les étiquettes ; prévenir le médecin et la direction ; une toxi-infection alimentaire collective (au moins deux cas groupés liés au même repas) est une maladie à déclaration obligatoire auprès de l'ARS	Coordinatrice
Retrait d'un partenaire qui oriente le public	2 × 3 = 6	Baisse des orientations sur deux mois	Plusieurs partenaires orienteurs ; restitution régulière des résultats	Activer d'autres relais (mairie, associations)	Coordinatrice

Définition – Plan de continuité

Ensemble des solutions prévues à l'avance pour qu'une action essentielle continue malgré un incident : un lieu de repli, une personne de remplacement, une recette sans cuisson, une version à distance. Il évite d'improviser dans l'urgence et rassure les partenaires et les financeurs.

Attention – Les risques pour les personnes passent avant les risques pour le projet

Un projet peut accepter un retard ou une baisse de participation. Il ne peut pas accepter un risque pour la santé ou la sécurité des participants : allergie, brûlure, coupure, intoxication, chute. Ces risques sont traités en priorité, même quand leur probabilité est faible, avec des règles écrites et connues de toute l'équipe.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.18

Un projet prévoit trois sorties au marché avec un groupe de personnes âgées, en minibus prêté par la mairie. Identifiez deux risques, puis remplissez pour chacun le signal d'alerte, la prévention et le plan de repli.

Corrigé

Exemples. Minibus indisponible : signal, la mairie n'a pas confirmé la réservation à J − 7 ; prévention, réserver les trois dates dès le début et confirmer à J − 7 ; repli, covoiturage avec des bénévoles assurés, ou sortie remplacée par la venue d'un producteur. Chute d'une personne au marché : signal, sol mouillé, foule, fatigue d'un participant ; prévention, groupe de six au plus par accompagnateur, horaire calme, bancs repérés, chaussures adaptées conseillées ; repli, trousse de premiers secours, numéros d'urgence, fiche de contact de

chaque participant.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.6 – Le pilotage

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la différence entre un indicateur de suivi et un indicateur de résultat ?
2. Que contient une fiche indicateur ? Citez cinq éléments.
3. Calculez le taux de présence cumulé de trois ateliers de 12 places avec 10, 9 et 8 présents.
4. Citez les cinq étapes qui mènent d'un écart à une décision.
5. Qu'est-ce qu'un plan de repli ?
6. Pourquoi traite-t-on un risque d'allergie même s'il est peu probable ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.6

1. L'indicateur de suivi dit si le projet se déroule comme prévu (activités, présence, budget, délais) ; l'indicateur de résultat dit si les objectifs sont atteints.
2. Nom, définition, formule, source, fréquence, responsable, valeur cible, seuil d'alerte (cinq suffisent).
3. (10 + 9 + 8) / (3 × 12) = 27 / 36 = **75,0 %**.
4. Constater, chercher les causes, lister les options, décider, vérifier l'effet.
5. La solution prévue à l'avance si un risque se réalise, pour que l'action continue.
6. Parce que sa gravité est maximale : il met en danger la santé d'une personne.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 8.3.7.
3 ou 4 sur 6	Je relis la fiche indicateur et la méthode de l'écart à la décision.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 8.3.6 et je refais les exercices d'application.

8.3.7 Élaborer le plan de communication du projet

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S2 §2 (p. 12)

Le référentiel cite explicitement le **plan de communication** parmi les indicateurs de la compétence C3.1. Il organise la manière dont on fait connaître le projet, on mobilise le public et les partenaires, et on valorise les résultats (fiche **F10** ; les techniques de communication sont approfondies aux chapitres 14 et 15).

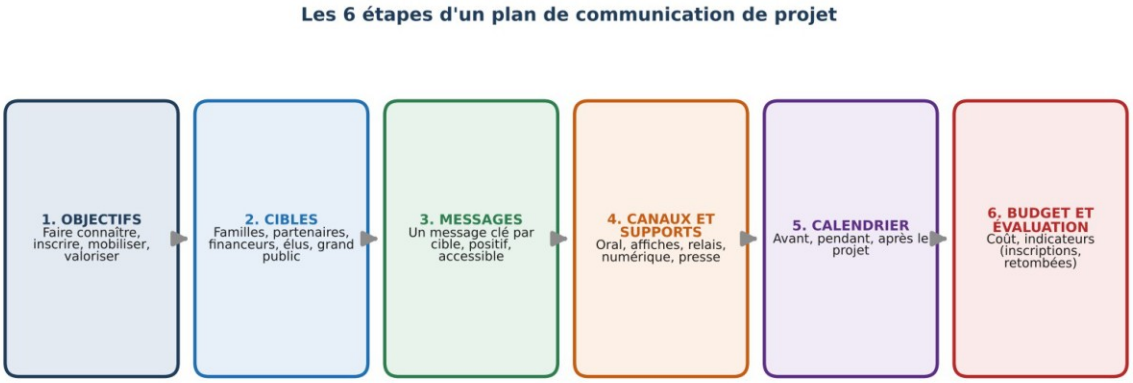


Figure 8.8 – Les étapes d'un plan de communication

Comprendre le schéma – Figure 8.8

1. Objectifs de communication : faire connaître le projet, susciter les inscriptions, mobiliser les partenaires, informer les financeurs, valoriser les résultats ; ils se distinguent des objectifs de santé du projet.

2. Cibles : public bénéficiaire (familles), relais (enseignants, travailleurs sociaux, mamans relais), partenaires, financeurs, élus, grand public.

3. Messages : un message clé par cible (« Venez cuisiner à petit prix avec vos enfants » pour les familles ; « Un projet qui réduit les inégalités d'accès à une alimentation favorable » pour les financeurs), clair et non stigmatisant (chapitres 5 et 6).

4. Canaux et supports : bouche-à-oreille et relais (souvent les plus efficaces auprès des publics éloignés), affiches et flyers imagés, messages vocaux, réseaux sociaux de la structure, presse locale, réunions.

5. Calendrier : avant (lancement, inscriptions), pendant (rappels, informations aux partenaires), après (restitution, valorisation, chapitre 9).

6. Budget et évaluation : coût des supports, temps humain ; indicateurs (nombre d'inscriptions par canal, fréquentation, retombées presse).

Cible	Objectif	Message	Canal, support	Quand
Familles du quartier	S'inscrire aux ateliers	« Cuisinons ensemble des repas bons et pas chers »	Mamans relais, affiches imagées, message vocal, inscription à l'accueil	3 semaines avant
Enseignants, PMI, épicerie	Orienter les familles	« Un cycle gratuit d'ateliers pour vos familles »	Réunion, courriel, flyer	4 semaines avant
Financeurs (ARS, commune, CAF)	Informer, rendre compte	« Le projet avance : 6 ateliers, 12 familles »	Point d'étape, bilan	Mi-parcours, fin
Élus, grand public	Faire connaître, valoriser	« Le quartier cuisine ! »	Journal municipal, temps fort, réseaux de la structure	Fin du cycle

Exemple – Calcul détaillé : efficacité des canaux de recrutement

Pour un cycle d'ateliers, 31 familles ont pris contact. Origine : mamans relais 14 ; affiche au centre social 6 ; orientation par l'épicerie solidaire 7 ; publication sur la page de la structure 2 ; flyer distribué à la sortie de l'école (300 flyers) 2.

- Vérification : 14 + 6 + 7 + 2 + 2 = **31** (vérifié).
- Parts : mamans relais 14 / 31 = **45,2 %** ; épicerie 7 / 31 = **22,6 %** ; affiche 6 / 31 = **19,4 %** ; page de la

structure 2 / 31 = **6,5 %** ; flyers 2 / 31 = **6,5 %**.

- Rendement des flyers : 2 contacts pour 300 flyers = 2 / 300 × 100 = **0,67 %** ; coût d'impression 45 € : 45 / 2 = **22,50 € par contact**.

Conclusion : auprès de ce public, les **relais humains** (mamans relais, épicerie) apportent deux tiers des contacts (21 / 31 = 67,7 %) ; les flyers sont peu efficaces : on réoriente le budget vers la formation des relais.

Rédiger un message clair et non stigmatisant

Le meilleur canal ne sert à rien si le message n'est pas compris ou s'il blesse. Un message de projet doit être **court**, **concret**, **positif** et **adapté** à la cible. Il dit ce que la personne va trouver, pas ce qui ne va pas chez elle. Les techniques de communication et l'écriture en facile à lire et à comprendre (FALC) sont développées aux chapitres 14 et 15 ; on retient ici ce qui concerne le projet.

Message à éviter	Pourquoi	Message reformulé
« Atelier pour les familles en difficulté »	Il désigne et stigmatise ; les personnes concernées ne viendront pas	« Atelier cuisine du mardi : des repas bons et pas chers, à faire en famille »
« Venez apprendre à bien manger »	Il suppose que les personnes mangent mal	« Venez découvrir des recettes rapides et partager vos astuces »
« Lutte contre l'obésité infantile »	Il étiquette les enfants et inquiète les parents	« Bouger et goûter : un mercredi par mois pour les 6-10 ans et leurs parents »
« Conférence sur les recommandations du PNNS »	Il est abstrait et peu attirant	« Les légumes secs, ça se cuisine comment ? Dégustation offerte »

Méthode pas à pas – Vérifier un message avant de le diffuser

1. Une seule idée principale, dite dans la première phrase ou le titre.

2. Les informations pratiques visibles : quoi, quand, où, combien (gratuit ?), comment s'inscrire, avec qui.

3. Des mots simples, des phrases courtes, des chiffres écrits en chiffres, une image qui montre l'activité (et non un aliment « interdit » barré).

4. Aucun mot qui juge les personnes ou leurs habitudes.

5. Un test auprès de deux ou trois personnes du public : ont-elles compris ? Ont-elles envie de venir ?

Exemple – Une affiche reformulée avec les habitantes

Une première affiche annonçait : « Programme nutrition : prévention du surpoids et des maladies cardiovasculaires ». Testée auprès de quatre habitantes, elle a été jugée « triste » et « pour les malades ». Avec elles, l'équipe a choisi un titre (« Cuisine du monde, petit budget »), une photo d'un atelier précédent (avec l'accord écrit des personnes photographiées) et trois informations en gros caractères : « Le mardi, 9 h 30 – 12 h », « Gratuit », « Inscription à l'accueil ou au 06… ». Les inscriptions ont été complètes en dix jours.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.19

Reformulez ce message destiné à des retraités vivant seuls : « Le CCAS organise un programme de prévention de la dénutrition chez les personnes âgées isolées. » Donnez un titre, une phrase d'accroche et les trois informations pratiques à faire figurer.

Corrigé

Exemple. Titre : « Les jeudis gourmands ». Accroche : « Un repas cuisiné ensemble, une fois par mois, pour le plaisir de partager et de découvrir des recettes simples. » Informations pratiques : « Un jeudi par mois, de 10 h à 14 h, à la salle des fêtes » ; « Participation : 3 € le repas » ; « Inscription au CCAS ou par téléphone ; transport possible sur demande ». Les mots « dénutrition », « personnes âgées » et « isolées » ne figurent pas : ils décrivent l'objectif de santé, pas l'activité, et risquent de faire fuir les personnes visées.

Communiquer avec les financeurs, les partenaires et les médias

Le plan de communication ne s'adresse pas seulement au public. Les financeurs et les partenaires attendent d'être **informés** et **cités** ; les élus et la presse peuvent **valoriser** le projet et faciliter sa pérennisation.

Destinataire	Ce qu'il attend	Bonnes pratiques
Financeurs	Que leur soutien soit visible et que le projet avance comme prévu	Apposer leur logo ou la mention prévue par la convention ; envoyer un point d'étape à mi-parcours ; les inviter au temps fort ; respecter leur charte graphique
Partenaires	Que leur rôle soit reconnu	Les citer sur les supports, valider avec eux les documents qui les concernent, leur transmettre les résultats agrégés
Élus	Des résultats concrets pour leur territoire	Une note courte, deux ou trois chiffres, une photo du temps fort, une proposition pour la suite
Presse locale	Une histoire, des personnes, une date	Un communiqué court, envoyé une semaine avant l'événement, avec un contact disponible

Définition – Communiqué de presse

Texte court (une page au plus) envoyé aux journalistes pour annoncer un événement ou un résultat. Il répond dès le premier paragraphe aux questions qui, quoi, où, quand, pourquoi ; il contient une citation d'un responsable, les informations pratiques et un contact. Le titre est informatif et concret.

Attention – Image des personnes et données

Une photo d'atelier publiée dans la presse ou sur un réseau social nécessite l'**accord écrit** des personnes reconnaissables (et des titulaires de l'autorité parentale pour un mineur), pour un usage précis. On ne publie jamais une information qui permet d'identifier la situation de santé ou sociale d'une personne. On peut photographier les mains, les plats, ou le groupe de dos (chapitre 6).

Exemple – Un communiqué de presse (extrait, projet fictif)

« **Les habitants du quartier des Peupliers ouvrent leur cuisine le 18 juin.** Samedi 18 juin, de 11 h à 14 h, sur la place du marché, douze familles qui ont suivi les ateliers "Cuisine du monde, petit budget" proposent une dégustation gratuite de leurs recettes. Le projet, porté par le centre social avec l'épicerie sociale et la PMI, a été soutenu par la commune et la caisse d'allocations familiales. "Nous avons appris à cuisiner les lentilles, et maintenant nous apprenons aux autres", explique une participante. Contact : coordinatrice du projet, centre social, 06… »

À vous de jouer – Exercice d'application 8.20

Un projet financé par l'ARS et la commune se termine par un repas partagé. Indiquez trois actions de communication à prévoir envers les financeurs, et une précaution à prendre si un journaliste vient

photographier le repas.

Corrigé

Exemples : inviter les représentants de l'ARS et de la commune au repas, avec un carton d'invitation envoyé trois semaines avant ; faire figurer leurs logos ou la mention de soutien sur l'affiche et sur le livret de recettes, selon les conventions ; leur adresser une note de bilan avec les principaux chiffres dans le mois qui suit. Précaution : recueillir l'accord écrit des personnes avant toute photo où elles sont reconnaissables, prévoir un espace sans photo pour ceux qui refusent, et relire les légendes pour qu'aucune information personnelle n'apparaisse.

Planifier et évaluer les actions de communication

Le plan de communication a besoin d'un **calendrier** et d'un **suivi**, comme le reste du projet. On construit le calendrier à rebours à partir de la date de l'action (8.3.4), puis on mesure, pour chaque canal, combien de personnes il a permis de toucher ou d'inscrire.

Échéance	Action de communication	Responsable
J − 6 semaines	Rencontre des relais (centre social, PMI, association de quartier) ; remise du message clé	Chef de projet
J − 4 semaines	Article dans le bulletin municipal (délai de bouclage à vérifier) ; affiches dans les commerces	Commune, bénévoles
J − 3 semaines	Publication sur les réseaux de la structure ; ouverture des inscriptions	Chargée de communication
J − 1 semaine	Communiqué de presse ; point sur les inscriptions et relance si besoin	Chef de projet
J − 1 jour	Rappel individuel des inscrits (message ou appel)	Animatrice
J + 1 semaine	Remerciements aux partenaires ; photos (avec accord) et chiffres clés	Chef de projet

Exemple – Calcul détaillé : quel canal a le mieux fonctionné ? (données fictives)

À l'inscription, on a demandé à chaque participant comment il avait connu l'atelier. Résultats pour 27 inscrits :

Canal	Dépense	Inscrits	Part des inscrits	Coût par inscrit
Affiches	60 €	4	14,8 %	15,00 €
Bulletin municipal	0 €	6	22,2 %	0 €
Relais formés (2 séances × 2 h × 45 €)	180 €	14	51,9 %	12,86 €
Réseau social (publication sponsorisée)	40 €	3	11,1 %	13,33 €
Total	280 €	27	100 %	10,37 €

- Parts : 4 / 27 = 14,8 % ; 6 / 27 = 22,2 % ; 14 / 27 = 51,9 % ; 3 / 27 = 11,1 %.
- Coûts par inscrit : 60 / 4 = **15,00 €** ; 180 / 14 = **12,86 €** ; 40 / 3 = **13,33 €** ; coût moyen 280 / 27 = **10,37 €**.

Interprétation : les relais apportent plus de la moitié des inscrits, pour un coût par inscrit inférieur à celui des affiches. Le bulletin municipal ne coûte rien et apporte 6 inscrits : on le garde. Pour le cycle suivant, on peut réduire les affiches et renforcer les relais. Attention : la formation des relais a aussi un effet durable (ils pourront relayer d'autres actions), que ce calcul ne mesure pas.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.21

Pour un second cycle, la structure dispose de 200 € pour la communication. Elle envisage de supprimer les affiches et la publication sponsorisée, et de consacrer tout le budget aux relais. Calculez le nombre d'inscrits attendu si le coût par inscrit des relais reste de 12,86 €, ajoutez les inscrits du bulletin municipal (6), puis discutez la limite de ce raisonnement.

Corrigé

Inscrits attendus par les relais : 200 / 12,86 = 15,55, soit environ 15 inscrits (on arrondit à l'entier inférieur pour rester prudent). Avec le bulletin municipal : 15 + 6 = 21 inscrits environ. Limite : le coût par inscrit n'est pas forcément constant ; les relais ont peut-être déjà mobilisé les personnes les plus faciles à toucher, et le nombre de relais disponibles est limité. Supprimer les affiches et les réseaux sociaux prive aussi le projet de publics que les relais ne connaissent pas. Il vaut mieux garder un petit budget pour un canal de diffusion large et suivre de nouveau l'origine des inscriptions.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.7 – Le plan de communication

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six éléments d'un plan de communication.
2. Pourquoi un objectif de communication est-il différent d'un objectif de santé ? Donnez un exemple.
3. Reformulez sans stigmatiser : « Atelier pour les personnes en surpoids ».
4. Quel canal est souvent le plus efficace auprès des publics éloignés des institutions ?
5. Que doit contenir le premier paragraphe d'un communiqué de presse ?
6. Que faut-il obtenir avant de publier la photo d'un participant ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.7

1. Objectifs de communication, cibles, messages, canaux et supports, calendrier, budget et évaluation.
2. L'objectif de communication porte sur la connaissance du projet ou la mobilisation (par exemple « remplir les 12 places en trois semaines ») ; l'objectif de santé porte sur un changement chez le public (par exemple « augmenter la consommation de légumes »).
3. Par exemple : « Bouger et cuisiner léger : un atelier convivial le jeudi soir ».
4. Les relais humains : pairs, relais formés, professionnels de confiance, bouche-à-oreille.
5. Qui, quoi, où, quand, pourquoi.
6. L'accord écrit de la personne (et des titulaires de l'autorité parentale pour un mineur), pour un usage précis.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 8.3.8.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau des messages à éviter.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 8.3.7 et je refais les exercices d'application.

8.3.8 Choisir les méthodes et les outils pédagogiques

Module · Référentiel et guide : voir 8.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Le plan d'action précise **comment** les objectifs éducatifs seront atteints. Le choix de la méthode dépend du **type d'objectif** (savoir, savoir-faire, savoir-être), du **public** et des **moyens**.

Méthode	Principe	Usage en nutrition
Expositive (transmissive)	L'intervenant présente, explique	Courte présentation des repères ; efficace pour des connaissances simples, insuffisante seule
Interrogative	L'intervenant fait découvrir par des questions	Quiz, « selon vous, pourquoi… ? » ; fait émerger les représentations
Démonstrative	L'intervenant montre, l'apprenant reproduit	Technique culinaire (cuisson des légumes secs), lecture d'étiquette
Active, expérientielle	L'apprenant agit, expérimente, puis analyse	Atelier culinaire, dégustation, jeu de rôle, défi, enquête de terrain
Coopérative	Travail en petits groupes, entraide	Cuisine en équipes, création collective d'un livret

Attention – Le mythe de la « pyramide de l'apprentissage »

On lit souvent que l'on retiendrait « 10 % de ce qu'on lit, 20 % de ce qu'on entend… 90 % de ce qu'on fait ». Ces pourcentages, attribués à tort à Edgar Dale, ne reposent sur aucune étude. Il est en revanche bien établi que l'**engagement actif**, la **pratique répétée** et le **retour d'information** favorisent l'apprentissage : c'est ce qui justifie les ateliers pratiques.

Type d'objectif	Méthodes et outils adaptés
Connaissances (citer les repères)	Exposé court illustré, quiz, jeux de cartes, photolangage
Savoir-faire (cuisiner, lire une étiquette)	Démonstration puis pratique, atelier culinaire, mise en situation en magasin
Attitudes (oser goûter, critiquer une publicité)	Dégustation sans pression, débat, analyse de publicités, témoignages de pairs
Comportements (consommer des légumes secs 2 fois par semaine)	Combinaison : pratique, défis à la maison, rappel, soutien du groupe, accès aux produits (environnement)

Formuler des objectifs pédagogiques

Une séance éducative se prépare à partir d'**objectifs pédagogiques**. Ils sont plus précis que les objectifs opérationnels du projet : ils décrivent ce que le participant saura **faire** à la fin de la séance. Un objectif pédagogique commence par un **verbe d'action observable** (citer, choisir, préparer, comparer), et non par un verbe vague (connaître, comprendre, prendre conscience).

Définition – Objectif pédagogique

Énoncé de ce que l'apprenant sera capable de faire à l'issue d'une séquence, formulé avec un verbe d'action observable, dans des conditions précisées, avec un critère de réussite. Exemple : « À la fin de l'atelier, chaque participant choisit, parmi cinq céréales du petit-déjeuner, celle qui contient le moins de sucres, en lisant le tableau nutritionnel pour 100 g. »

La **taxonomie de Bloom** (Bloom, 1956), révisée par Anderson et Krathwohl (2001), classe les objectifs cognitifs du plus simple au plus complexe. Elle aide à choisir le bon verbe et à vérifier que la séance ne se limite pas à la mémorisation.

Niveau (version révisée, 2001)	Ce que fait le participant	Verbes utiles	Exemple en nutrition
Se souvenir	Il retrouve une information	Citer, nommer, lister	Citer trois légumes secs
Comprendre	Il explique avec ses mots	Expliquer, reformuler, classer	Expliquer pourquoi les légumes secs rassasient

Niveau (version révisée, 2001)	Ce que fait le participant	Verbes utiles	Exemple en nutrition
Appliquer	Il utilise une règle dans une situation	Calculer, préparer, utiliser	Préparer une portion de lentilles pour un adulte
Analyser	Il décompose, compare	Comparer, distinguer, repérer	Comparer deux étiquettes de plats préparés
Évaluer	Il juge selon des critères	Justifier, choisir, critiquer	Choisir le menu le plus équilibré et justifier son choix
Créer	Il produit quelque chose de nouveau	Concevoir, composer, inventer	Composer les menus d'une semaine avec un budget donné

Méthode – Rédiger un objectif pédagogique en quatre éléments

1. **Qui ?** Le participant (et non l'animateur : « présenter les repères » est une activité de l'animateur, pas un objectif).
2. **Quoi ?** Un verbe d'action observable et son complément.
3. **Dans quelles conditions ?** Avec quel support, quel matériel, quelle aide.
4. **Avec quel critère de réussite ?** Un seuil vérifiable (« sans erreur », « au moins trois sur cinq », « en moins de 10 minutes »).

Formulation à éviter	Pourquoi	Formulation correcte
« Sensibiliser les parents au sucre »	Verbe vague, centré sur l'animateur	« Chaque parent estime, avec des morceaux de sucre, la quantité de sucres contenue dans trois boissons courantes, avec au plus une erreur »
« Que les jeunes comprennent l'équilibre alimentaire »	Non observable	« Chaque jeune compose un plateau repas comportant les composantes du repère, à partir d'un choix d'images »
« Faire un atelier cuisine »	C'est une activité, pas un objectif	« Les participants préparent en binôme une soupe de légumes de saison en suivant une fiche recette illustrée »

Construire le conducteur de séance

Le **conducteur** (ou déroulé) est le document qui organise la séance minute par minute. Il permet à un autre animateur de reprendre la séance, il sert de support au bilan et il est souvent demandé dans un dossier de financement.

Exemple – Conducteur d'un atelier de 90 minutes « Goûters malins » (public : parents d'enfants de 6 à 10 ans, projet fictif)

Objectif pédagogique principal : « À la fin de l'atelier, chaque parent compose trois goûters associant un produit céréalier, un fruit et un produit laitier ou une boisson sans sucre ajouté, pour un coût inférieur à 0,80 € par enfant. »

Temps	Durée	Activité	Méthode	Matériel	Rôle de l'animateur
0 – 10 min	10	Accueil, présentation, règles du groupe	Tour de table	Badges, feuille d'émargement	Accueillir, rappeler la confidentialité
10 – 25 min	15	« Le goûter de mon enfant » : chacun décrit un goûter habituel	Photolangage	Photos de goûters	Faire émerger les représentations, ne pas juger

Temps	Durée	Activité	Méthode	Matériel	Rôle de l'animateur
25 – 40 min	15	Repères : rôle du goûter, composition, sucres cachés	Exposé court interactif	Affiche, emballages vides	Reformuler les apports du groupe
40 – 70 min	30	Préparation de trois goûters en équipes	Atelier pratique coopératif	Denrées, ustensiles, fiches recettes	Circuler, aider, vérifier l'hygiène
70 – 80 min	10	Dégustation et calcul du coût par enfant	Calcul guidé	Tickets de caisse, calculatrice	Valoriser chaque équipe
80 – 90 min	10	Bilan : « ce que je vais essayer cette semaine », questionnaire	Écrit court et oral	Questionnaire, livret	Recueillir les données d'évaluation

Astuce – Équilibrer la séance

Une règle pratique consiste à limiter l'exposé à **15 minutes d'affilée** et à alterner les temps où l'animateur parle et ceux où les participants agissent. Le temps de bilan final n'est jamais supprimé : c'est lui qui fournit les données de l'évaluation de processus et de résultats (chapitre 9).

À vous de jouer – Exercice d'application 8.22

Réécrivez ces trois énoncés sous la forme d'objectifs pédagogiques, puis indiquez le niveau de la taxonomie révisée de Bloom correspondant.

a) « Informer les seniors sur les protéines. »

b) « Apprendre aux étudiants à faire leurs courses. »

c) « Que les participants connaissent les féculents. »

Corrigé

a) « À la fin de la séance, chaque participant cite au moins trois aliments sources de protéines qu'il peut consommer au dîner, dont un d'origine végétale. » (Se souvenir.) On peut viser plus haut : « … compose un dîner apportant une source de protéines à partir d'une liste d'aliments » (Créer ou Appliquer).

b) « À partir d'un budget de 25 € et d'une liste de prix, chaque étudiant établit une liste de courses pour quatre repas, comprenant des légumes et un féculent à chaque repas. » (Créer.)

c) « Chaque participant classe dix aliments en "féculents" et "autres", avec au plus une erreur. » (Comprendre.)

Dans les trois cas, le verbe vague (informer, apprendre, connaître) est remplacé par une action observable, et un critère de réussite est ajouté.

Choisir et analyser un outil pédagogique

Un **outil pédagogique** (jeu, exposition, mallette, vidéo, photolangage, application) est un support qui aide l'animateur à atteindre un objectif. Avant de l'utiliser, on vérifie qu'il est **fiable**, **adapté au public** et **cohérent avec l'objectif**. Un outil séduisant mais dépassé ou culpabilisant peut produire l'effet inverse de celui recherché.

En France, l'INPES a publié en 2005 un référentiel de critères de qualité des outils d'intervention en éducation pour la santé (Lemonnier et al., *Outils d'intervention en éducation pour la santé : critères de qualité*, INPES, 2005). Il organise l'analyse autour de quatre axes : le **contenu**, la **pédagogie**, le **support** et la **conception** de l'outil. Les centres de ressources documentaires du réseau Promotion Santé (anciennes Ireps) prêtent des outils et accompagnent leur choix.

Axe	Questions à se poser	Exemple de point faible
Contenu	Les informations sont-elles exactes, à jour, sourcées ? Sont-elles cohérentes avec les recommandations actuelles (PNNS, Santé publique France) ?	Un jeu qui présente encore la « pyramide alimentaire » des années 1990
Pédagogie	L'outil fait-il participer ? Laisse-t-il de la place aux représentations ? Évite-t-il la culpabilisation et la peur ?	Des cartes « bons » et « mauvais » aliments, qui moralisent
Support	Est-il lisible, solide, transportable, accessible (langue, illustrations, handicap) ?	Des textes longs pour un public peu lecteur
Conception	Qui l'a conçu, avec quel financement, a-t-il été testé auprès du public ? Y a-t-il un intérêt commercial ?	Un outil fourni gratuitement par une marque qui met ses produits en avant

Attention – Les outils offerts par l'industrie

Un outil financé par une entreprise agroalimentaire n'est pas forcément faux, mais il présente un **risque de conflit d'intérêts** : messages orientés, logos, produits mis en scène. En éducation pour la santé, on privilégie les outils d'organismes publics ou associatifs indépendants et on vérifie systématiquement la présence de marques. Ce point est attendu à l'épreuve E5.

Méthode – Analyser un outil en six questions

1. Quel est l'**objectif** de l'outil, et correspond-il à mon objectif pédagogique ?
2. À quel **public** est-il destiné (âge, niveau de lecture, culture) ?
3. Le **contenu** est-il exact et daté ? Qui l'a conçu, et y a-t-il un intérêt commercial ?
4. Quelle **démarche** propose-t-il : transmettre, faire découvrir, faire débattre, faire pratiquer ?
5. Quelles **conditions** d'utilisation : durée, nombre de participants, matériel, formation de l'animateur ?
6. Quelles **adaptations** sont nécessaires, et comment évaluer son effet ?

Exemple – Analyse d'un outil fictif : le jeu « Le marché de Léo »

Jeu de plateau pour enfants de 8 à 11 ans : chaque équipe dispose d'un budget fictif et doit « acheter » un repas équilibré. Conçu en 2019 par une association de consommateurs, testé dans quatre écoles. Contenu : repères alimentaires de Santé publique France publiés en 2019, sans marques. Points forts : démarche active, travail en équipe, lien avec le budget. Points faibles : prix des cartes datés de 2019, à actualiser ; une carte présente les jus de fruits comme pouvant remplacer tous les fruits de la journée, alors que les repères actuels demandent de limiter les jus de fruits à un petit verre par jour au plus. Conclusion : outil retenu, après correction des prix et retrait de la carte sur les jus.

Contexte	Outil souvent adapté	Précaution
Public peu lecteur ou allophone	Photolangage, aliments réels, pictogrammes	Vérifier que les images correspondent aux habitudes culturelles du groupe
Adolescents	Défi, quiz sur smartphone, analyse de publicités, jeu de rôle	Éviter le ton moralisateur, laisser débattre
Personnes âgées	Atelier cuisine, dégustation, souvenirs alimentaires	Adapter les gestes (préhension), la lisibilité et la durée
Groupe nombreux en événement	Stand interactif, roue des questions, exposition	Prévoir un relais humain pour répondre aux questions

À vous de jouer – Exercice d'application 8.23

Une enseigne de boissons propose gratuitement à un collège un kit pédagogique intitulé « Bien s'hydrater », avec affiches et quiz. Les affiches portent le logo de la marque, et le quiz présente une boisson aromatisée de la marque comme « idéale pour le sport ». Analysez ce kit selon les quatre axes du référentiel de 2005, puis donnez votre décision argumentée.

Corrigé

Contenu : le message « boisson aromatisée idéale pour le sport » est contraire au repère (l'eau est la seule boisson indispensable ; les boissons sucrées sont à limiter). Pédagogie : le quiz peut être participatif, mais il oriente les réponses vers un produit. Support : probablement attractif. Conception : outil conçu par une entreprise, avec un intérêt commercial évident (logo, produit cité). Décision : on refuse le kit ; on le remplace par un outil indépendant (centre de ressources du réseau Promotion Santé, Santé publique France) ou on construit un quiz sur l'eau et les boissons sucrées avec les élèves. On informe la direction de la raison du refus.

Animer un groupe : posture et situations délicates

La meilleure séance sur le papier peut échouer si l'animation ne permet pas à chacun de participer. En éducation pour la santé, l'animateur n'est pas un « expert qui sait » face à des participants « qui ne savent pas » : il **facilite** les échanges, part de ce que vivent les participants et les aide à trouver leurs propres solutions.

Technique d'animation	Comment faire	Effet recherché
Questions ouvertes	« Comment faites-vous pour… ? », « Qu'est-ce qui vous aide ? » plutôt que « Est-ce que vous mangez des légumes ? »	Faire parler, recueillir des expériences
Reformulation	« Si je comprends bien, le soir, vous manquez de temps pour cuisiner »	Montrer que l'on a écouté, vérifier sa compréhension
Valorisation	Souligner une idée, un effort, une réussite	Renforcer la confiance en soi et l'envie de continuer
Faire circuler la parole	Tour de table, travail en binôme, « qui n'a pas encore donné son avis ? »	Éviter que quelques personnes monopolisent l'échange
Synthèse	Résumer les idées du groupe à la fin de chaque temps	Fixer les acquis, faire le lien avec la suite

Définition – Écoute active

Attitude qui consiste à écouter sans interrompre ni juger, à montrer son attention (regard, hochements de tête), à reformuler et à poser des questions ouvertes pour aider la personne à préciser sa pensée. Elle est issue des travaux de Carl Rogers sur l'approche centrée sur la personne et elle est à la base de l'entretien motivationnel.

Situation délicate	Réponse possible de l'animateur
Un participant monopolise la parole	Le remercier, résumer son idée, puis s'adresser aux autres : « Merci, c'est une piste. Qu'en pensent les autres ? » ; si besoin, proposer un tour de parole
Un participant conteste les repères (« les nutritionnistes changent d'avis tout le temps »)	Accueillir l'objection sans se braquer, expliquer simplement d'où viennent les repères et pourquoi ils évoluent, revenir à l'expérience concrète du groupe

Situation délicate	Réponse possible de l'animateur
Une personne raconte une situation personnelle difficile	L'écouter brièvement, la remercier de sa confiance, proposer d'en parler après la séance, l'orienter si besoin vers un professionnel adapté
Un participant se moque d'un autre (poids, habitudes)	Rappeler calmement les règles du groupe fixées au début (respect, non-jugement, confidentialité)
Le groupe ne participe pas	Changer de méthode : travail en binôme, activité pratique, question plus concrète, photolangage

Attention – Rester dans son rôle

Dans un atelier collectif, on ne donne pas de conseil diététique individuel sur une pathologie : on oriente vers une consultation. On évite aussi de juger les aliments (« bons » ou « mauvais ») et les personnes. Une remarque culpabilisante peut suffire à faire partir un participant, souvent celui qui avait le plus besoin de l'atelier.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.24

Pendant un atelier pour des parents, une mère déclare : « De toute façon, mes enfants ne mangent que des pâtes, j'ai tout essayé. » Proposez une réponse de l'animateur qui utilise l'écoute active, puis une façon d'impliquer le groupe.

Corrigé

Réponse : « Vous avez déjà beaucoup essayé, et c'est décourageant quand les enfants refusent. Qu'est-ce que vous avez tenté jusqu'ici ? » La reformulation montre que l'on a compris la difficulté, sans juger, et la question ouverte invite à préciser. Implication du groupe : « Est-ce que d'autres parents ont vécu la même chose ? Qu'est-ce qui a marché chez vous ? » Le groupe partage ses astuces (ajouter des légumes dans la sauce des pâtes, faire participer les enfants à la cuisine, proposer plusieurs fois sans forcer). L'animateur complète en rappelant que l'acceptation d'un aliment nouveau demande souvent plusieurs présentations.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.8 – Les méthodes et les outils pédagogiques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi « sensibiliser les participants » n'est-il pas un objectif pédagogique ?
2. Citez les quatre éléments d'un objectif pédagogique bien rédigé.
3. Classez du plus simple au plus complexe : évaluer, se souvenir, appliquer.
4. Quelle méthode convient le mieux pour apprendre à cuisiner des légumes secs ?
5. Citez les quatre axes d'analyse d'un outil pédagogique.
6. Quel risque présente un outil offert par une entreprise agroalimentaire ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.8

1. Le verbe est vague et non observable, et il décrit l'action de l'animateur, pas ce que le participant saura faire.
2. Qui (le participant), quoi (un verbe d'action observable), dans quelles conditions, avec quel critère de réussite.
3. Se souvenir, appliquer, évaluer.
4. Une méthode démonstrative suivie d'une pratique (atelier culinaire, méthode active).
5. Le contenu, la pédagogie, le support et la conception.

6. Un conflit d'intérêts : messages orientés vers ses produits, présence de marques.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 8.3.9.
3 ou 4 sur 6	Je relis la méthode de rédaction d'un objectif et le tableau des axes.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 8.3.8 et je refais les exercices d'application.

8.3.9 Organiser la logistique des ateliers

Module · Référentiel : C3.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Prévoir les quantités : mise à l'échelle et rendement

Pour un atelier culinaire, on calcule les quantités à acheter à partir des recettes de base (fiche F8) en tenant compte du **nombre de portions** et du **rendement** des produits (part comestible après épluchage, parage, cuisson).

Exemple – Calcul détaillé : liste de courses pour un cycle de 3 ateliers

Recette de base pour 4 personnes ; chaque atelier sert **12 portions** (coefficient 12 / 4 = **3**) ; rendements usuels (ordres de grandeur) : carottes 85 % de partie comestible après épluchage ; pommes de terre 80 % ; oignons 90 % ; pommes 85 %.

- **Carottes** (300 g épluchés pour 4 personnes dans la recette) : 300 × 3 = 900 g épluchés par atelier ; poids brut = 900 / 0,85 = **1 059 g**, soit environ **1,1 kg** ; pour 3 ateliers utilisant la recette : 1,059 × 3 = **3,18 kg**, arrondis à **3,2 kg**.
- **Pommes de terre** (600 g épluchés) : 600 × 3 / 0,80 = 1 800 / 0,80 = **2 250 g** brut par atelier.
- **Lentilles corail** (160 g secs) : 160 × 3 = **480 g** (pas de perte).
- **Coût** des carottes : 3,2 kg × 1,40 €/kg = **4,48 €**.

Pourquoi c'est important : oublier le rendement conduit à manquer d'ingrédients (900 g achetés ne donnent que 765 g épluchés : 900 × 0,85) ; surestimer conduit au gaspillage.

La check-list logistique

Avant l'atelier (J − 7 à J − 1)	Commandes et courses (liste chiffrée), vérification du matériel (balance, ustensiles, four), réservation de la salle, confirmation des inscriptions (rappel la veille), impression des fiches, fiche d'allergies, trousse de secours
Jour J	Installation 30 minutes avant, mise en place par poste, affichage des recettes et des allergènes, émargement
Après	Rangement, nettoyage, inventaire du matériel et des restes de denrées, bilan à chaud, saisie des données d'évaluation, compte rendu

Maîtriser l'hygiène pendant un atelier culinaire

Un atelier culinaire manipule des denrées périssables, souvent dans une salle qui n'est pas une cuisine professionnelle. Le diététicien est responsable de la **sécurité sanitaire** de ce qu'il fait préparer et goûter. Les règles générales d'hygiène des denrées sont fixées par le **règlement (CE) n° 852/2004** du 29 avril 2004 ; les températures et les règles de la remise directe au consommateur sont précisées en France par l'**arrêté du 21 décembre 2009** relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail.

Un atelier où les participants préparent et consomment ensemble leur propre repas n'a pas toujours le même statut qu'un restaurant. Les bonnes pratiques d'hygiène s'appliquent néanmoins dans tous les cas, et elles

deviennent indispensables dès que des denrées sont servies à un public extérieur (dégustation lors d'un forum, buffet de fin de projet). En cas de doute, on se renseigne auprès de la direction départementale chargée de la protection des populations (DDPP ou DDETSPP).

Point de maîtrise	Règle à appliquer	Pourquoi
Lavage des mains	À l'arrivée, après être allé aux toilettes, après avoir touché des œufs crus, de la viande ou des déchets ; savon, essuie-mains à usage unique	Les mains sont le premier vecteur de contamination
Tenue	Cheveux attachés ou charlotte, tablier propre, bijoux retirés, plaie protégée par un pansement et un gant	Éviter les contaminations physiques et microbiennes
Chaîne du froid	Transport en sac isotherme ; denrées très périssables stockées entre 0 et + 4 °C ; temps hors du froid le plus court possible	Limiter la multiplication des bactéries
Marche en avant	Séparer les zones et les ustensiles « sale » (épluchage, viande crue) et « propre » (produits prêts à consommer)	Éviter les contaminations croisées
Cuisson	Cuire à cœur les viandes hachées et les volailles ; ne pas servir d'œufs crus ou peu cuits aux publics fragiles	Détruire les bactéries pathogènes
Maintien au chaud	Au moins + 63 °C jusqu'au service	Empêcher la multiplication bactérienne
Refroidissement	Passer de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures, puis stocker entre 0 et + 3 °C (arrêté du 21 décembre 2009)	Traverser vite la zone de températures dangereuse
Restes	Ne pas redonner les restes servis ; jeter ce qui est resté à température ambiante	Éviter les toxi-infections

Définition – Toxi-infection alimentaire collective (TIAC)

Apparition d'au moins deux cas groupés de symptômes similaires, en général digestifs, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire. La TIAC est une **maladie à déclaration obligatoire** auprès de l'agence régionale de santé (ARS). Le registre des risques du projet (8.3.6) prévoit la conduite à tenir.

Attention – Les publics fragiles

Les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées sont plus vulnérables à certaines bactéries (*Listeria*, salmonelles). Pour ces publics, on évite dans les ateliers les produits à risque : œufs crus (mousse au chocolat, mayonnaise maison), lait cru, fromages au lait cru pour les femmes enceintes, poissons crus, graines germées crues.

Informer sur les allergènes

Le **règlement (UE) n° 1169/2011** (règlement INCO) liste en annexe II **14 substances ou produits** provoquant des allergies ou des intolérances, qui doivent être signalés au consommateur. Pour les denrées non préemballées, comme un buffet ou une dégustation, le **décret n° 2015-447 du 17 avril 2015** impose que l'information soit donnée **par écrit** ou rendue accessible au consommateur.

Les 14 allergènes à déclarer (annexe II du règlement 1169/2011)	
Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut)	Crustacés

Les 14 allergènes à déclarer (annexe II du règlement 1169/2011)	
Œufs	Poissons
Arachides	Soja
Lait (y compris le lactose)	Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, noix de cajou, de pécan, du Brésil, pistaches, noix de Macadamia)
Céleri	Moutarde
Graines de sésame	Anhydride sulfureux et sulfites (au-delà de 10 mg par kg ou par litre)
Lupin	Mollusques

Méthode – Gérer les allergies dans un atelier

1. Demander les allergies et les régimes particuliers **à l'inscription**, par écrit, et les reporter sur une fiche confidentielle.
2. Choisir des recettes compatibles avec le groupe, ou prévoir une variante préparée à part, avec des ustensiles propres.
3. Lire **toutes** les étiquettes des produits achetés : les allergènes sont mis en évidence dans la liste des ingrédients.
4. Afficher le jour même, pour chaque recette, la liste des allergènes présents.
5. Connaître la conduite à tenir en cas de réaction (appel du 15 ou du 112) et savoir si la personne dispose d'un stylo d'adrénaline.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.25

Pour un buffet de fin de projet ouvert aux familles, vous prévoyez : un houmous (pois chiches, crème de sésame, citron, huile d'olive), des bâtonnets de carottes, un pain aux noix et un taboulé (semoule de blé, persil, tomates). Établissez l'affichage des allergènes, puis indiquez deux précautions d'hygiène pour le service.

Corrigé

Houmous : sésame (crème de sésame). Bâtonnets de carottes : aucun des 14 allergènes. Pain aux noix : gluten (blé) et fruits à coque (noix) ; vérifier l'étiquette du pain pour d'éventuels œufs, lait ou sésame. Taboulé : gluten (semoule de blé). L'affichage est écrit, placé à côté de chaque plat. Précautions : garder le houmous et le taboulé au froid jusqu'au service et ne pas les laisser plus de deux heures à température ambiante ; prévoir une cuillère par plat pour éviter qu'un allergène passe d'un plat à l'autre ; jeter les restes du buffet.

Commander, réceptionner et stocker les denrées

La logistique d'un atelier repose sur trois documents simples : le **bon de commande** (ou la liste de courses chiffrée), la **fiche de réception** et la **fiche de stock**. Ils évitent les oublis et le gaspillage, et ils servent de justificatifs pour le budget réalisé (8.3.5).

Exemple – Calcul détaillé : bon de commande d'un velouté pour 30 portions (prix fictifs)

Recette de base pour 10 portions : 1,2 kg de potimarron épépiné, 150 g d'oignons épluchés, 0,5 L de lait demi-écrémé, épices et bouillon. Coefficient : 30 / 10 = **3**. Rendements retenus (ordres de grandeur) : potimarron 75 % après épépinage, oignons 90 %.

- **Potimarron** : 1,2 × 3 = 3,6 kg épépiné ; poids brut = 3,6 / 0,75 = **4,8 kg** ; coût 4,8 × 2,20 = **10,56 €**.

- **Oignons** : 0,150 × 3 = 0,450 kg épluché ; poids brut = 0,450 / 0,90 = **0,5 kg** ; coût 0,5 × 1,80 = **0,90 €**.
- **Lait** : 0,5 × 3 = 1,5 L, mais il est vendu en bouteilles de 1 L : on achète **2 L**, soit 2 × 1,05 = **2,10 €**.
- **Épices et bouillon** (forfait) : **0,60 €**.
- **Total** : 10,56 + 0,90 + 2,10 + 0,60 = **14,16 €**, soit 14,16 / 30 = **0,47 €** par portion (0,472 arrondi).

Ce qu'il faut retenir : le conditionnement de vente oblige parfois à acheter plus que le besoin ; le demi-litre de lait restant est prévu pour une autre recette ou rendu à la structure.

Étape	Ce que l'on vérifie	Document
Commande	Quantités calculées avec le coefficient et le rendement ; budget disponible ; délai de livraison	Bon de commande, devis
Réception	Température des produits frais (au toucher ou avec un thermomètre), état des emballages, dates, conformité à la commande	Fiche de réception, bon de livraison
Stockage	Froid entre 0 et + 4 °C pour les produits frais ; produits secs à l'abri de l'humidité, au-dessus du sol ; produits d'entretien séparés des aliments	Fiche de stock, relevé de température du réfrigérateur
Utilisation	Rotation des stocks : premier entré, premier sorti ; contrôle des dates avant usage	Fiche de stock mise à jour

Définition – DLC et DDM

La **date limite de consommation** (DLC), mentionnée « à consommer jusqu'au », concerne les denrées très périssables : au-delà, le produit peut présenter un danger et ne doit pas être utilisé. La **date de durabilité minimale** (DDM), mentionnée « à consommer de préférence avant », concerne les produits stables (pâtes, conserves, biscuits) : au-delà, le produit peut perdre en qualité, mais il ne présente pas de danger s'il a été bien conservé et si l'emballage est intact.

Astuce – Réduire le gaspillage dans un projet

Les produits secs à DDM dépassée de peu, donnés par une épicerie solidaire, peuvent être utilisés en atelier s'ils sont en bon état. Les restes de légumes crus peuvent servir à un bouillon préparé le jour même. Les quantités réellement consommées sont notées à chaque atelier : elles servent à ajuster les commandes suivantes et constituent un indicateur du projet.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.26

Une recette de salade de lentilles pour 6 personnes demande 240 g de lentilles vertes sèches, 300 g de carottes épluchées (rendement 85 %) et 90 g d'oignons rouges épluchés (rendement 90 %). Calculez les quantités à acheter pour un atelier de 18 personnes, sachant que les lentilles sont vendues en sachets de 500 g. Indiquez ensuite où et comment stocker chaque produit avant l'atelier.

Corrigé

Coefficient : 18 / 6 = 3. Lentilles : 240 × 3 = 720 g, soit 2 sachets de 500 g (1 000 g achetés, 280 g de reste à stocker). Carottes : 300 × 3 = 900 g épluchées, soit 900 / 0,85 = 1 058,8 g, environ 1,06 kg brut. Oignons rouges : 90 × 3 = 270 g épluchés, soit 270 / 0,90 = 300 g brut. Stockage : les lentilles dans un placard sec, au-dessus du sol, sachet refermé ; les carottes au réfrigérateur ou dans un local frais ; les oignons dans un endroit sec, frais et aéré, à l'abri de la lumière.

Rendre les ateliers accessibles à tous

Un atelier conçu pour « tout le monde » peut exclure sans le vouloir : salle à l'étage sans ascenseur, fiches recettes écrites en petits caractères, recette incompatible avec les habitudes alimentaires d'une partie du groupe, horaire incompatible avec le travail. La logistique fait partie de la lutte contre les inégalités sociales de santé (chapitre 7).

Obstacle	Adaptation possible
Mobilité réduite	Salle de plain-pied ou accessible par ascenseur, plan de travail à hauteur adaptée, transport solidaire, chaises pendant les temps longs
Troubles de la vue	Fiches en gros caractères, contrastes forts, description orale des gestes, ustensiles faciles à repérer
Difficultés de lecture ou de compréhension	Recettes illustrées étape par étape, pictogrammes, documents en « facile à lire et à comprendre » (FALC)
Langue	Interprète ou participant relais, supports visuels, aliments réels plutôt que des mots
Habitudes alimentaires culturelles ou religieuses	Recettes sans porc ou sans alcool, version végétarienne, recettes proposées par les participants
Contraintes horaires	Créneaux variés (soir, samedi), garde d'enfants pendant l'atelier
Coût	Gratuité ou participation symbolique, produits accessibles dans les commerces proches

Définition – Facile à lire et à comprendre (FALC)

Méthode de rédaction qui rend l'information accessible aux personnes ayant une déficience intellectuelle, et utile aussi aux personnes qui lisent difficilement : phrases courtes, un message par phrase, mots simples, illustrations, mise en page aérée. Les règles européennes du FALC ont été établies par l'association Inclusion Europe ; un document FALC est relu par des personnes concernées.

Exemple – Une recette réécrite pour être accessible

Version initiale : « Faire revenir l'oignon émincé dans l'huile, ajouter les lentilles préalablement rincées et mouiller à hauteur. » Version accessible, avec une photo par étape : « 1. Coupez l'oignon en petits morceaux. 2. Mettez 1 cuillère d'huile dans la casserole. 3. Faites cuire l'oignon 5 minutes. 4. Lavez les lentilles dans une passoire. 5. Mettez les lentilles dans la casserole. 6. Ajoutez de l'eau : l'eau doit couvrir les lentilles. »

À vous de jouer – Exercice d'application 8.27

Un atelier est prévu dans la salle du premier étage d'une mairie (sans ascenseur), le mardi à 14 h, avec une recette de rôti de porc au cidre et des fiches recettes en texte continu. Le public : des familles d'un quartier où vivent beaucoup de personnes qui travaillent en horaires décalés, dont certaines sont arrivées récemment en France. Relevez quatre obstacles et proposez une adaptation pour chacun.

Corrigé

1. Salle à l'étage sans ascenseur : choisir une salle de plain-pied (centre social, cuisine d'une école). 2. Horaire unique en semaine : proposer un créneau le samedi matin ou en fin de journée, et une garde d'enfants. 3. Recette au porc et à l'alcool : choisir une recette compatible avec tous (par exemple un plat de légumes secs) ou proposer une variante, et associer les familles au choix. 4. Fiches en texte continu : recettes illustrées étape par étape, pictogrammes, mots simples, éventuellement traduites ou expliquées par un participant relais.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.9 – La logistique et l'hygiène des ateliers

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pour 24 portions d'une recette prévue pour 8, avec 400 g de carottes épluchées et un rendement de 80 %, quel poids brut faut-il acheter ?
2. Quelle température minimale faut-il respecter pour le maintien au chaud ?
3. En combien de temps un plat doit-il passer de + 63 °C à moins de + 10 °C ?
4. Combien d'allergènes doivent être signalés selon le règlement INCO ? Citez-en quatre.
5. Quelle est la différence entre une DLC et une DDM ?
6. Que signifie « premier entré, premier sorti » ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.9

1. Coefficient 24 / 8 = 3 ; 400 × 3 = 1 200 g épluchés ; 1 200 / 0,80 = 1 500 g, soit 1,5 kg brut.
2. Au moins + 63 °C.
3. En moins de 2 heures.
4. Quatorze ; par exemple gluten, lait, œufs, arachides, fruits à coque, sésame, soja, moutarde, céleri, poissons, crustacés, mollusques, lupin, sulfites.
5. Après la DLC, le produit peut être dangereux et ne doit pas être consommé ; après la DDM, il peut perdre en qualité mais reste sans danger s'il a été bien conservé.
6. On utilise d'abord les produits arrivés les premiers (rotation des stocks), pour éviter de dépasser les dates.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 8.3.10.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau des points de maîtrise et la liste des allergènes.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 8.3.9 et je refais les exercices d'application.

8.3.10 Anticiper la trésorerie du projet

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Un budget peut être **équilibré** sur l'année et pourtant poser un problème de **trésorerie** : les dépenses arrivent avant les recettes (les subventions sont souvent versées plusieurs mois après la notification). Le **plan de trésorerie** prévoit, mois par mois, les encaissements, les décaissements et le solde.

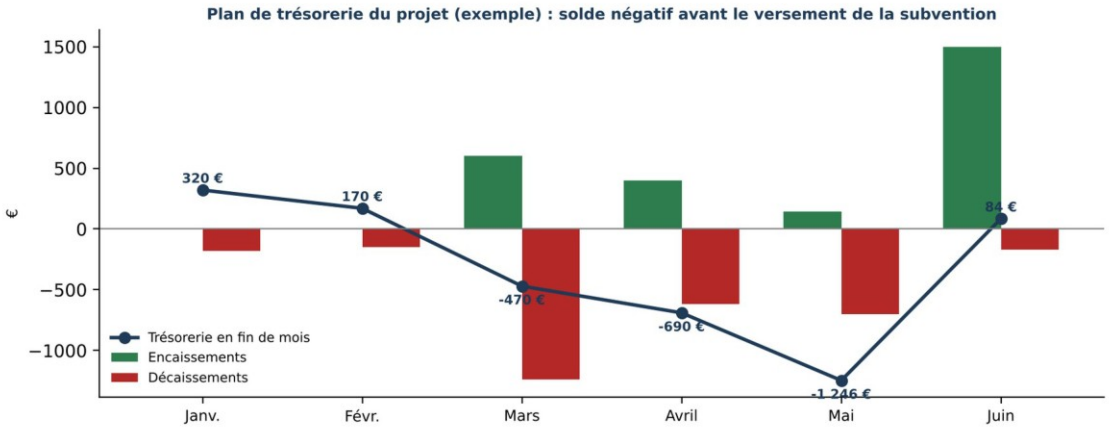


Figure 8.9 – Un plan de trésorerie mois par mois

Exemple – Calcul détaillé : le plan de trésorerie du projet des Tilleuls (hors contributions en nature)

Trésorerie disponible au départ (réserve affectée par le centre social) : **500 €**. Dépenses monétaires prévues : 3 060 € (3 510 € − 450 € de contributions en nature) ; recettes : commune 600 € (mars), CAF 400 € (avril), familles 144 € (mai), ARS 1 500 € (juin).

Mois	Encaissements	Décaissements	Calcul	Solde fin de mois
Janvier	0	180	500 + 0 − 180	320
Février	0	150	320 − 150	170
Mars	600	1 240	170 + 600 − 1 240	− 470
Avril	400	620	− 470 + 400 − 620	− 690
Mai	144	700	− 690 + 144 − 700	− 1 246
Juin	1 500	170	− 1 246 + 1 500 − 170	84

- Vérification : décaissements 180 + 150 + 1 240 + 620 + 700 + 170 = **3 060 €** ; encaissements 600 + 400 + 144 + 1 500 = **2 644 €** ; 500 + 2 644 − 3 060 = **84 €** (la différence 3 060 − 2 644 = **416 €** est l'autofinancement).
- **Besoin de trésorerie maximal** : **1 246 €** fin mai.

Solutions : demander une **avance** sur subvention (certains financeurs versent un acompte à la notification), décaler des achats, mobiliser la trésorerie générale de la structure, solliciter le versement anticipé de la part communale. Ce risque (R3, 8.3.6) doit être anticipé avec la direction dès la conception.

Comparer les solutions à un besoin de trésorerie

Quand le plan de trésorerie fait apparaître un solde négatif, le chef de projet ne se contente pas de le constater : il **chiffre plusieurs solutions**, les compare et propose la plus réaliste à la direction. Chaque solution a un coût ou une contrainte.

Solution	Effet sur la trésorerie	Contrainte
Demander une avance (acompte) au financeur	Encaissement plus tôt	Dépend des règles du financeur ; à prévoir dans la convention
Décaler des achats non urgents	Décaissement plus tard	Ne doit pas retarder une tâche du chemin critique (8.3.4)
Échelonner un paiement avec un fournisseur	Décaissement étalé	Accord du fournisseur
Mobiliser la trésorerie générale de la structure	Couvre le creux	Possible seulement si la structure a des réserves ; accord de la direction ou du bureau
Emprunter (prêt de trésorerie, découvert autorisé)	Couvre le creux	Coût des intérêts, garanties ; rarement adapté à un petit projet associatif

Exemple – Calcul détaillé : le plan de trésorerie d'un projet « Bien manger pour mieux jouer » (club de football amateur, données fictives)

Le club porte un projet d'ateliers pour ses licenciés de 11 à 14 ans, de septembre à février. Trésorerie de départ : **300 €**. Recettes : participation des familles 240 € (octobre), commune 800 € (novembre), mécénat d'un commerce local 360 € (décembre), conseil départemental 1 600 € (février, après le bilan intermédiaire).

Mois	Encaissements	Décaissements	Calcul	Solde fin de mois
Septembre	0	250	300 + 0 − 250	50
Octobre	240	900	50 + 240 − 900	− 610
Novembre	800	650	− 610 + 800 − 650	− 460

Mois	Encaissements	Décaissements	Calcul	Solde fin de mois
Décembre	360	400	− 460 + 360 − 400	− 500
Janvier	0	700	− 500 + 0 − 700	− 1 200
Février	1 600	300	− 1 200 + 1 600 − 300	100

- Vérification : décaissements 250 + 900 + 650 + 400 + 700 + 300 = **3 200 €** ; encaissements 240 + 800 + 360 + 1 600 = **3 000 €** ; 300 + 3 000 − 3 200 = **100 €**.
- **Besoin de trésorerie maximal** : **1 200 €** fin janvier. Le solde est négatif pendant quatre mois.

Solution A : avance de 50 % du conseil départemental en octobre (800 € en octobre, 800 € en février). Soldes : 50 ; 190 ; 340 ; 300 ; **− 400** ; 100. Le besoin maximal tombe à **400 €**, en janvier seulement.

Solution B : décaler l'achat du matériel pédagogique (400 €) d'octobre à février, sans changer les recettes. Soldes : 50 ; − 210 ; − 60 ; − 100 ; **− 800** ; 100. Le besoin maximal tombe à **800 €**, mais le solde reste négatif quatre mois, et le matériel arrive tard.

Solutions A et B combinées. Soldes : 50 ; 590 ; 740 ; 700 ; **0** ; 100. Le solde n'est jamais négatif.

Conclusion argumentée : la solution A est la plus efficace, mais elle dépend de l'accord du conseil départemental. Le chef de projet la demande dès le dépôt du dossier. Si elle est refusée, il combine la solution B (pour une partie seulement du matériel, afin de ne pas pénaliser les premiers ateliers) avec une mobilisation de la trésorerie du club, à faire valider par le bureau.

Attention – Budget et trésorerie ne se confondent pas

Le budget répond à la question « le projet est-il financé ? » ; le plan de trésorerie répond à la question « aura-t-on l'argent au moment de payer ? ». Les contributions en nature (8.3.5) figurent au budget mais jamais dans le plan de trésorerie, puisqu'elles ne donnent lieu à aucun mouvement d'argent.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.28

Reprenez le plan de trésorerie du club de football. Le commerce local propose de verser son mécénat de 360 € en octobre au lieu de décembre. Recalculez les soldes mensuels sans avance du conseil départemental, puis indiquez le nouveau besoin maximal.

Corrigé

Encaissements : octobre 240 + 360 = 600 ; décembre 0. Soldes : septembre 300 − 250 = 50 ; octobre 50 + 600 − 900 = − 250 ; novembre − 250 + 800 − 650 = − 100 ; décembre − 100 + 0 − 400 = − 500 ; janvier − 500 − 700 = − 1 200 ; février − 1 200 + 1 600 − 300 = 100. Le besoin maximal reste de **1 200 €** en janvier : avancer le mécénat améliore octobre et novembre, mais pas le creux de janvier, qui vient du versement tardif du conseil départemental. La seule solution efficace pour janvier est d'avancer une recette importante ou de décaler une dépense de janvier.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.10 – La trésorerie du projet

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi un budget équilibré peut-il poser un problème de trésorerie ?
2. Comment calcule-t-on le solde de fin de mois ?
3. Trésorerie de départ 200 €, encaissements du mois 500 €, décaissements 900 € : quel est le solde ?
4. Les contributions en nature figurent-elles dans le plan de trésorerie ? Pourquoi ?
5. Citez trois solutions à un besoin de trésorerie.

6. Quelle précaution prendre avant de décaler un achat ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.10

1. Parce que les dépenses arrivent souvent avant les recettes, les subventions étant versées plusieurs mois après la notification.
2. Solde du mois précédent + encaissements du mois − décaissements du mois.
3. 200 + 500 − 900 = − 200 €.
4. Non, car elles ne donnent lieu à aucun mouvement d'argent.
5. Par exemple : demander une avance au financeur, décaler des achats non urgents, échelonner un paiement, mobiliser la trésorerie de la structure.
6. Vérifier que l'achat ne concerne pas une tâche du chemin critique, pour ne pas retarder le projet.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 8.3.11.
3 ou 4 sur 6	Je refais le calcul du plan de trésorerie du club de football.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 8.3.10 et je refais les exercices d'application.

8.3.11 Rédiger un dossier de demande de financement : exemple commenté

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Exemple – Extraits commentés de la réponse du centre social à l'appel à projets de l'ARS

Contexte et constats (½ page) : « Le quartier des Tilleuls (4 200 habitants, quartier prioritaire) présente un taux de pauvreté de 41 % (15 % à Valmont) et 14 % d'enfants de grande section en surpoids (9 % dans le département). L'enquête menée auprès de 48 parents en juin 2027 montre que 71 % jugent qu'une alimentation équilibrée coûte cher et que 58 % ne savent pas cuisiner les légumes secs ; 54 % souhaitent des ateliers. L'environnement alimentaire est dominé par la restauration rapide (indice d'environnement favorable de 28,6 / 100). » → *Commentaire : données locales chiffrées, sourcées et datées, besoins exprimés et normatifs.* **Inscription dans les politiques** : « Le projet répond à l'axe 2 du PNNS 5, à la priorité du PRS sur la nutrition des enfants en quartier prioritaire et à la fiche-action 3 du contrat local de santé. » → *Reprise du vocabulaire du financeur.* **Objectifs** : objectif général et 4 objectifs spécifiques SMART (fiche F3). → *Indicateurs et valeurs initiales mentionnés.* **Actions et méthodes** : « 6 ateliers culinaires participatifs (méthodes actives et démonstratives), une visite accompagnée du marché, un livret de 12 recettes testées, un partenariat avec l'épicerie solidaire (convention) pour l'accès aux produits. » → *Combinaison éducation et environnement.* **Public et participation** : « 12 familles orientées par l'épicerie, les écoles et la PMI ; recettes du monde choisies par les familles ; deux mamans relais associées au comité de pilotage. » → *Participation et universalisme proportionné.* **Évaluation** : « Processus (ateliers réalisés, taux de présence ≥ 80 %) ; résultats (questionnaire avant/après : légumes secs, connaissances ; satisfaction). » → *Indicateurs alignés sur les objectifs.* **Budget** : « Coût total 3 510 €, dont 450 € de contributions en nature ; subvention sollicitée 1 500 € (42,7 %) ; cofinancements de la commune (600 €), de la CAF (400 €), participation des familles (144 €) et autofinancement (416 €). » → *Budget équilibré, cofinancé.* **Pérennisation** : « Formation de deux mamans relais et de la référente, conducteurs réutilisables, intégration au projet social. » → *Argument souvent décisif.*

Attention – Un dossier de financement n'est pas un dossier d'examen

Le dossier de financement est rédigé **avant** l'action, pour convaincre ; le dossier de l'épreuve E5 rend compte de **votre** démarche et de **votre** analyse, y compris des difficultés et des ajustements. Les mêmes données peuvent servir aux deux, mais la rédaction, personnelle, et l'analyse critique sont propres au dossier

d'examen.

8.3.12 La convention de partenariat : un modèle commenté

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S2 §2 (p. 12)

Exemple – Convention entre le centre social des Tilleuls et l'épicerie solidaire « Le Panier partagé » (extraits commentés) Article 1 – Objet : « La présente convention définit les modalités de collaboration entre les parties pour la mise en œuvre du projet "Bien manger, petit budget, grand plaisir" (mars-mai 2028). » → *Un objet précis, limité dans le temps.* **Article 2 – Engagements du centre social** : « Concevoir et animer 6 ateliers culinaires ; réserver 6 places aux familles orientées par l'épicerie ; transmettre un bilan agrégé ; mentionner le partenariat sur les supports. » → *Engagements concrets et vérifiables.* **Article 3 – Engagements de l'épicerie** : « Orienter les familles intéressées ; fournir les légumes secs et produits de base des ateliers dans la limite de 60 € ; proposer en rayon les produits utilisés dans les recettes ; participer au comité de pilotage. » → *Chaque partenaire apporte quelque chose et y trouve un intérêt (chapitre 8.3.2).* **Article 4 – Communication** : « Les supports mentionnent les deux structures ; toute publication est validée conjointement. » → *Évite les malentendus sur l'image.* **Article 5 – Données personnelles et confidentialité** : « Aucune donnée nominative n'est échangée sans l'accord écrit des personnes ; les bilans sont agrégés et anonymes. » → *Conformité RGPD (chapitre 6).* **Article 6 – Suivi et évaluation** : « Un point d'étape à mi-parcours ; bilan commun en juin. » **Article 7 – Durée, modification, résiliation** : « La convention prend effet à la signature et s'achève le 30 juin 2028 ; elle peut être modifiée par avenant ou résiliée par l'une des parties avec un préavis d'un mois. » **Signatures** des représentants légaux (présidente de l'association du centre social, président du CCAS ou son délégué).

Attention – Ce qui fragilise un partenariat

Des engagements flous (« participer au projet »), un déséquilibre (un partenaire qui donne sans rien recevoir), l'absence de point d'étape, une communication non concertée, un départ de la personne référente sans passation. Une convention ne remplace pas la **relation** : rencontres régulières, remerciements, restitution des résultats.

Relire son dossier avant le dépôt : la grille d'autocontrôle

Un dossier de financement est souvent lu rapidement, par un instructeur qui en examine plusieurs dizaines. Un dossier incomplet ou incohérent est écarté, même si le projet est bon. Avant le dépôt, le chef de projet relit donc le dossier avec une **grille d'autocontrôle**, idéalement avec une autre personne qui ne l'a pas rédigé.

Critère	Question de contrôle	Oui / Non
Éligibilité	Le porteur, le public, le territoire et les dates correspondent-ils au cahier des charges ?	
Complétude	Toutes les rubriques sont-elles remplies ? Toutes les pièces sont-elles jointes (statuts, RIB, budget, comptes, attestations) ?	
Cohérence	Les constats justifient-ils les objectifs ? Les actions permettent-elles d'atteindre les objectifs ?	
Chiffres	Les chiffres sont-ils identiques partout (nombre de bénéficiaires, montants, dates) ? Le budget est-il équilibré ?	
Indicateurs	Chaque objectif opérationnel a-t-il au moins un indicateur, une valeur cible et une source ?	
Partenariats	Les partenaires cités ont-ils donné leur accord écrit (lettre de soutien, convention) ?	

Critère	Question de contrôle	Oui / Non
Lisibilité	Les phrases sont-elles courtes, sans jargon ? Les sigles sont-ils expliqués ? Un résumé ouvre-t-il le dossier ?	
Calendrier	Le dépôt est-il fait avant la date limite, avec une marge pour les problèmes techniques ?	

Erreurs fréquentes – Ce qui fait écarter un dossier

- Un projet qui ne correspond pas aux **priorités** de l'appel (public ou thème hors champ).
- Un budget **déséquilibré**, ou une demande qui dépasse le plafond ou le taux maximal de financement.
- Des **objectifs** formulés comme des activités (« faire six ateliers ») et sans indicateurs.
- Des chiffres qui changent d'une page à l'autre : 12 familles dans la présentation, 15 dans le budget.
- Des partenaires cités sans leur accord, ou une absence totale de partenariat quand l'appel le demande.
- Un dépôt la dernière heure, bloqué par une plateforme saturée.

Méthode – Rédiger le résumé du projet en dix lignes

Le résumé est souvent la seule partie lue en entier par tous les membres du comité de sélection. Il tient en dix lignes au plus et répond, dans l'ordre, à cinq questions :

1. **Quel problème ?** Un constat chiffré et sourcé.
2. **Pour qui ?** Le public et le territoire.
3. **Quoi ?** Les actions principales et leur calendrier.
4. **Avec qui ?** Les partenaires et leur rôle.
5. **Pour quels résultats ?** Les objectifs et deux ou trois indicateurs, et le montant demandé.

Exemple – Un résumé de projet (projet fictif)

« Dans la résidence autonomie des Glycines (52 résidents), le diagnostic réalisé en 2027 montre que 23 % des résidents ont perdu plus de 5 % de leur poids en un an et que 40 % sautent régulièrement le dîner. Le projet "Le dîner, ça se partage" propose, d'octobre 2027 à juin 2028, un dîner partagé mensuel préparé avec les résidents, six ateliers "dîners faciles" animés par une diététicienne et la formation de deux agents à la surveillance du poids. Il associe le CCAS, le service d'aide à domicile et une association de bénévoles. Objectifs : 30 résidents participants, une baisse de moitié du nombre de résidents sautant le dîner, une pesée mensuelle pour tous. Montant demandé : 6 200 €, soit 62 % d'un budget de 10 000 €. »

À vous de jouer – Exercice d'application 8.29

Relisez ce passage d'un dossier et relevez au moins quatre défauts, en vous aidant de la grille d'autocontrôle : « Le projet s'adresse aux jeunes du quartier. Il s'agit de sensibiliser à l'alimentation par des ateliers. Nous accueillerons 20 jeunes (budget établi pour 25 participants). Partenaires : collège, mission locale, supermarché voisin (contact prévu en septembre). Montant demandé : 9 000 €, soit 90 % du budget (taux maximal de l'appel : 80 %). »

Corrigé

1. Le public est flou (« les jeunes du quartier ») : il faut préciser l'âge, le nombre et les critères. 2. L'objectif est vague (« sensibiliser ») et sans indicateur. 3. Les chiffres sont incohérents : 20 jeunes dans le texte, 25 dans le budget. 4. Les partenaires ne sont pas engagés (un contact « prévu » n'est pas un accord) et le supermarché pose une question de conflit d'intérêts. 5. Le taux demandé (90 %) dépasse le maximum de l'appel (80 %) : le dossier est inéligible tant que le cofinancement n'est pas augmenté. Pour 10 000 € de

budget, la demande ne peut pas dépasser 10 000 × 0,80 = 8 000 €.

Les clauses sensibles d'une convention

Le modèle commenté ci-dessus (8.3.12) présente les clauses de base d'une convention : objet, engagements de chaque partie, durée, suivi. D'autres clauses sont souvent oubliées alors qu'elles évitent les conflits. Le diététicien ne rédige pas seul les clauses juridiques : il les prépare avec la direction de la structure, qui signe la convention.

Clause	Ce qu'elle prévoit	Question à se poser
Durée et renouvellement	Date de début, date de fin, renouvellement exprès ou tacite	Que se passe-t-il à la fin du projet ?
Moyens mis à disposition	Locaux, matériel, temps de personnel, denrées, avec leur valorisation	Qui assure le matériel prêté en cas de casse ?
Responsabilité et assurance	Chaque partie garantit les dommages causés par ses salariés et ses bénévoles ; attestation d'assurance	L'assurance de la structure couvre-t-elle les activités culinaires et les bénévoles ?
Données personnelles	Qui collecte, qui conserve, pendant combien de temps, qui peut consulter (règlement général sur la protection des données, chapitre 6)	Les données des participants circulent-elles entre partenaires ? Avec quel accord ?
Communication et propriété des supports	Logos, mention des partenaires, droit d'utiliser les recettes, photos et livrets après le projet	Qui peut réutiliser le livret de recettes ? Sous quelle forme ?
Résiliation	Conditions dans lesquelles une partie peut mettre fin à la convention (préavis, motif)	Que devient l'action si un partenaire se retire ?
Règlement des litiges	Recherche d'une solution amiable d'abord, puis tribunal compétent	Qui contacter en cas de désaccord ?

Définition – Tacite reconduction

Clause selon laquelle une convention est renouvelée automatiquement à son échéance, pour la même durée, si aucune des parties ne la dénonce. Pour un projet limité dans le temps, on préfère souvent un **renouvellement exprès** (une nouvelle signature), qui oblige à faire le bilan avant de continuer.

Attention – Convention de partenariat et convention de financement

La convention de partenariat organise une **collaboration** entre structures (qui fait quoi). La convention de financement (ou d'attribution de subvention, 8.3.3) fixe les **obligations liées à l'argent** : montant, modalités de versement, compte rendu financier, éventuel reversement des sommes non utilisées. Les deux documents ne se confondent pas, même si l'un peut citer l'autre.

Exemple – Une clause « données » rédigée simplement (projet fictif)

« Article 7 – Données personnelles. Le centre social est seul responsable de la collecte des données des participants (nom, téléphone, réponses aux questionnaires). Ces données sont conservées sur son serveur, accessibles à la coordinatrice et à la diététicienne du projet, et supprimées douze mois après la fin du projet. L'association partenaire ne reçoit que des résultats agrégés, sans nom. Chaque participant est informé de ses droits (accès, rectification, effacement) au moment de l'inscription. »

À vous de jouer – Exercice d'application 8.30

Une association de jardins familiaux prête une parcelle et deux bénévoles à un centre social pour des ateliers « du jardin à l'assiette ». Proposez le contenu de trois clauses sensibles de la convention : assurance, communication, résiliation.

Corrigé

Assurance : chaque structure assure ses salariés et ses bénévoles ; le centre social vérifie que son contrat couvre les activités extérieures (jardin) et les participants ; les deux parties échangent leurs attestations avant le premier atelier. Communication : le nom et le logo de l'association figurent sur l'affiche et le livret ; les photos prises au jardin ne sont diffusées qu'avec l'accord écrit des personnes ; le livret de recettes peut être réutilisé par les deux parties, avec mention de l'autre. Résiliation : chaque partie peut mettre fin à la convention avec un préavis d'un mois, par écrit ; les ateliers déjà programmés sont maintenus ou reportés en accord avec les participants.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.12 – Le dossier et la convention

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi faire relire un dossier de financement par une personne qui ne l'a pas rédigé ?
2. Citez trois erreurs qui font écarter un dossier.
3. À quelles cinq questions répond le résumé d'un projet ?
4. Un appel à projets finance au plus 70 % d'un budget de 8 000 €. Quel montant maximal peut-on demander ?
5. Qu'est-ce qu'une clause de tacite reconduction ?
6. Quelle différence y a-t-il entre une convention de partenariat et une convention de financement ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.12

1. Parce qu'un regard extérieur repère plus facilement les incohérences, les oublis et les passages peu clairs.
2. Par exemple : projet hors des priorités de l'appel, budget déséquilibré ou taux dépassé, objectifs sans indicateurs, chiffres incohérents, partenaires non engagés, dépôt hors délai.
3. Quel problème ? Pour qui ? Quoi ? Avec qui ? Pour quels résultats (et quel montant) ?
4. 8 000 × 0,70 = 5 600 €.
5. Une clause qui renouvelle automatiquement la convention à son échéance si aucune partie ne la dénonce.
6. La convention de partenariat organise la collaboration (qui fait quoi) ; la convention de financement fixe les obligations liées à la subvention (montant, versement, compte rendu).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 8.3.13.
3 ou 4 sur 6	Je relis la grille d'autocontrôle et le tableau des clauses.
Moins de 3 sur 6	Je relis les parties 8.3.11 et 8.3.12 et je refais les exercices d'application.

8.3.13 Estimer la charge de travail et tenir une feuille de temps

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Un plan d'action réaliste suppose d'estimer le **temps** nécessaire à chaque tâche : c'est souvent la ressource la plus rare (et le premier poste du budget, chapitre 8.3.5). La **feuille de temps** (fiche F5) permet ensuite de comparer le temps prévu et le temps réellement passé.

Méthode pas à pas – Estimer la charge d'une tâche

1. Décomposer chaque action en tâches élémentaires (préparer un atelier = conducteur + fiche technique + courses + installation + animation + rangement + bilan).

2. Estimer la durée de chaque tâche à partir de l'expérience (ou de celle de la tutrice).

3. Multiplier par le nombre de répétitions (6 ateliers).

4. Ajouter une marge pour les imprévus (en général 15 à 25 %).

5. Comparer au temps disponible (heures de stage, temps des partenaires) et arbitrer.

Exemple – Calcul détaillé : charge de préparation et d'animation d'un cycle de 6 ateliers

Tâche	Durée unitaire (h)	Nombre	Total (h)	Remarque
Conducteur et fiche technique	2,5	6	15	Moins long à partir du 3e atelier
Courses	1	6	6	
Installation et rangement	1	6	6	
Animation	3	6	18	
Bilan à chaud et saisie	0,5	6	3	
Questionnaires (conception, saisie, analyse)	–	–	10	Avant et après
Réunions (tutrice, COPIL)	1,5	4	6	
Sous-total			64	

- Sous-total : 15 + 6 + 6 + 18 + 3 + 10 + 6 = **64 h**.
- Marge de 20 % : 64 × 0,20 = **12,8 h** ; total prévisionnel : 64 + 12,8 = **76,8 h**, soit environ **77 h**.
- Temps disponible (période 2 de stage, 4 semaines de 35 h, dont 30 % consacrés à d'autres activités de la structure) : 140 × 0,70 = **98 h** ; le cycle tient dans le temps disponible, avec 98 − 77 = **21 h** pour la communication et le livret.
- **Comparaison au réalisé** (chapitre 1, feuille de temps d'Inès) : la préparation des ateliers a pris 38 h au lieu de 25 h prévues au départ, soit (38 − 25) / 25 × 100 = **+ 52 %** : sans marge, le planning aurait dérapé ; c'est un point d'auto-évaluation (fiche F14).

Attention – Le temps des partenaires compte aussi

Un projet mobilise le temps de la tutrice, de la diététicienne, des bénévoles et des partenaires : il faut le **prévoir**, le **demander** explicitement (convention) et le **valoriser** dans le budget (comptes 64 ou 86-87). Un partenaire surchargé est un risque pour le projet.

8.3.14 Utiliser les outils numériques du projet

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Le référentiel cite, parmi les outils et moyens de la démarche de projet, les **logiciels de gestion de projet**, le **mind-mapping** (carte mentale), le **tableur** et le **formulaire en ligne**. Ces outils ne remplacent pas la méthode : ils la rendent plus rapide, plus lisible et plus facile à partager. Leur usage est encadré par les règles de protection des données (chapitre 6) et de sécurité numérique (chapitre 21).

Outil	À quoi il sert dans le projet	Exemples d'usage	Points de vigilance
Carte mentale (mind-mapping)	Organiser des idées autour d'un thème central, en branches et sous-branches ; visualiser un problème ou un plan	Brainstorming du diagnostic, préparation de l'arbre à problèmes, plan du dossier E5, carte des partenaires	Rester lisible (un mot-clé par branche) ; ne pas confondre une carte d'idées avec un diagnostic validé par des données
Logiciel de gestion de projet	Lister les tâches, les attribuer, fixer des échéances, suivre l'avancement (liste, tableau à colonnes « à faire / en cours / fait », diagramme de Gantt)	Planning des ateliers, suivi des tâches entre la stagiaire, la tutrice et les partenaires, jalons du comité de pilotage	Choisir un outil autorisé par la structure ; ne pas y déposer de données personnelles des participants
Tableur	Calculer, organiser des données, produire des graphiques	Budget prévisionnel et réalisé, plan de trésorerie, tableau de bord, saisie et dépouillement des questionnaires, feuille de temps	Formules vérifiées, cellules protégées, une version de référence datée ; pseudonymiser les données des participants
Formulaire en ligne	Recueillir des réponses à distance, dans un format directement exploitable par le tableur	Questionnaire de diagnostic, inscription aux ateliers, questionnaire de satisfaction	RGPD : information des personnes, minimisation des données, durée de conservation, hébergement ; pas de données de santé sans cadre adapté
Plateforme collaborative et espace de stockage partagé	Partager et co-écrire des documents, garder une version unique à jour	Fiches projet, conducteurs de séance, comptes rendus	Droits d'accès limités aux personnes concernées ; liens de partage non publics (chapitre 21)

La carte mentale

Définition – Carte mentale (mind map)

Représentation graphique, rayonnante, de la pensée : un **thème central** au milieu de la page, des **branches principales** (idées clés), puis des **sous-branches** (détails), avec des mots-clés, des couleurs et parfois des pictogrammes. La méthode a été popularisée par Tony Buzan dans les années 1970. Elle se réalise sur papier ou avec un logiciel de cartographie mentale (il en existe des versions libres et gratuites).

Méthode pas à pas – Construire la carte mentale d'un diagnostic en 4 étapes

1. Écrire au centre le **sujet** : « Alimentation des familles du quartier des Tilleuls ».
2. Créer une **branche par type de données** : données objectives, besoins exprimés, besoins ressentis, besoins observés, ressources du territoire, politiques publiques.
3. Ajouter sur chaque branche les **constats** en mots-clés, avec leur source (« 71 % : manger équilibré coûte cher
   – questionnaire »).
4. **Relier** par des flèches les constats qui s'expliquent mutuellement : la carte prépare l'arbre à problèmes (chapitre 7).

Le logiciel de gestion de projet

Un logiciel de gestion de projet permet de découper le projet en **tâches**, de leur affecter un **responsable**, une **échéance**, une **durée** et des **dépendances** (une tâche ne peut commencer qu'après une autre), puis de visualiser l'ensemble sous forme de **liste**, de **tableau à colonnes** (méthode inspirée du kanban : « à faire », « en cours », « fait ») ou de **diagramme de Gantt** (8.3.4). L'outil calcule automatiquement les dates et signale les retards.

Exemple – Le tableau à colonnes d'Inès (extrait, semaine du 13 mars 2028)

À faire	En cours	Fait
Commander les denrées de l'atelier 3 (Inès, avant le 24/03)	Rédiger le conducteur de l'atelier 3 (Inès, 21/03)	Atelier 1 « légumes secs » animé le 7/03
Réserver le bus pour la visite du marché (Mme Martin, 20/03)	Saisir les questionnaires « avant » dans le tableur (Inès, 17/03)	Atelier 2 « légumes de saison » animé le 14/03
Préparer l'ordre du jour du comité de pilotage (Inès, 27/03)		Affiches et flyers diffusés

Lecture : chaque carte porte une tâche, un responsable et une échéance ; en réunion d'équipe, on déplace les cartes d'une colonne à l'autre. Le nombre de tâches « en cours » doit rester limité pour éviter la dispersion.

Le tableur

Le tableur est l'outil le plus utilisé dans un projet de santé publique : budget (fiche F6), tableau de bord (F12), dépouillement des questionnaires (F11), feuille de temps. Quelques fonctions suffisent dans la plupart des cas.

Fonction	Ce qu'elle fait	Exemple dans le projet
=B2*C2	Multiplie deux cellules	Montant d'une ligne de budget = quantité × coût unitaire
=SOMME(D2:D10)	Additionne une plage	Total des charges
=MOYENNE(B2:B13)	Calcule la moyenne	Score moyen de connaissances des 12 participants
=MEDIANE(B2:B13)	Calcule la médiane	Score médian, moins sensible aux valeurs extrêmes
=NB.SI(C2:C49;"Oui")	Compte les cellules qui remplissent une condition	Nombre de parents qui souhaitent des ateliers
=NB.SI(C2:C49;"Oui")/ NBVAL(C2:C49)	Calcule une proportion	Part des parents qui souhaitent des ateliers (format %)
=D2-C2 et =(D2-C2)/C2	Calcule un écart absolu et un écart relatif	Écart entre le budget réalisé et le budget prévu

Exemple – Calcul détaillé : un tableau de bord dans le tableur

Dans la feuille « tableau de bord », la colonne B contient la valeur prévue, la colonne C la valeur réalisée.

- Ligne 2, ateliers réalisés : prévu 6, réalisé 6 ; taux de réalisation =C2/B2 → 6 / 6 = **100 %**.
- Ligne 3, présences : prévu 72 (12 familles × 6 ateliers), réalisé 61 ; taux =C3/B3 → 61 / 72 = 0,847, soit **84,7** % (objectif ≥ 80 % atteint).
- Ligne 4, dépenses de denrées : prévu 210 €, réalisé 236 € ; écart =C4-B4 → **+ 26 €** ; écart relatif =(C4-B4)/B4 → 26 / 210 = 0,124, soit **+ 12,4 %**.
- Une **mise en forme conditionnelle** (cellule verte si l'objectif est atteint, orange sinon) rend le tableau lisible en comité de pilotage.

(Données fictives.)

Le formulaire en ligne

Le formulaire en ligne (questionnaire diffusé par un lien ou un QR code) facilite le recueil et le dépouillement : les réponses arrivent directement dans un tableur. Il ne convient pas à tous les publics : prévoir **toujours** une

version papier ou une passation accompagnée pour les personnes éloignées du numérique (précarité numérique, chapitres 5 et 15).

Attention – Formulaire en ligne et RGPD : la liste de contrôle

- **Utiliser l'outil validé par la structure** : vérifier où sont hébergées les données (de préférence dans l'Union européenne) et qui y a accès.
- **Minimiser** : ne demander que les informations utiles à l'objectif ; un questionnaire de satisfaction peut être **anonyme** (pas de nom, pas d'adresse électronique obligatoire).
- **Informer** les personnes en tête du formulaire : responsable du traitement, finalité, caractère facultatif, durée de conservation, droits (accès, rectification, effacement) et contact.
- **Données de santé** (poids, maladie, traitement) : ce sont des données sensibles (article 9 du RGPD) ; ne pas les recueillir par un formulaire grand public sans cadre adapté (consentement explicite, hébergement et sécurité appropriés), demander l'avis du responsable de la structure ou du délégué à la protection des données.
- **Sécuriser et supprimer** : accès protégé par mot de passe, export dans un dossier sécurisé, suppression des réponses à la fin de la durée annoncée.

À vous de jouer – Exercice d'application – Choisir l'outil numérique adapté

Pour chacun des besoins suivants, indiquez l'outil le plus adapté et une précaution : a) préparer, avec l'équipe, le plan du dossier de projet ; b) suivre qui fait quoi et pour quand pendant les six semaines d'ateliers ; c) calculer le coût par famille et l'écart au budget prévu ; d) recueillir l'avis de 80 parents d'élèves sur le goûter.

Corrigé

a) Carte mentale (sur papier ou logiciel), partagée sur l'espace collaboratif de la structure ; précaution : la faire valider par la tutrice avant de rédiger. **b) Logiciel de gestion de projet** (tableau à colonnes ou Gantt) ; précaution : outil autorisé par la structure, aucune donnée personnelle des familles. **c) Tableur** : =SOMME() pour le total, =total/12 pour le coût par famille, =(réalisé − prévu)/prévu pour l'écart relatif ; précaution : vérifier les formules et dater la version. **d) Formulaire en ligne** diffusé par le cahier de liaison ou un QR code, **avec une version papier** ; précaution : questionnaire anonyme, information RGPD en tête, durée de conservation annoncée.

Travailler en équipe avec des documents partagés

Un projet de prévention se mène à plusieurs : chef de projet, tutrice, animateurs, partenaires, parfois bénévoles. Les documents circulent (tableau de bord, budget, conducteurs, questionnaires). Sans règles communes, on perd du temps à chercher la bonne version, et l'on risque de diffuser des données personnelles par erreur.

Méthode – Organiser les fichiers du projet en quatre règles

1. **Une arborescence simple et partagée**, décidée au lancement : par exemple 01_Diagnostic, 02_Conception, 03_Financement, 04_Ateliers, 05_Communication, 06_Évaluation, 07_Bilan.
2. **Un nommage normalisé** des fichiers : date à l'envers, objet, version. Exemple : 2028-03-14_conducteur_atelier2_v3. La date à l'envers permet de classer les fichiers dans l'ordre chronologique.
3. **Une seule version de référence** : on travaille dans le document partagé, ou l'on indique clairement qui détient la version en cours de modification. La version validée est marquée « VALIDÉ » ou déposée dans un dossier à part.
4. **Des accès limités** : les fichiers contenant des données personnelles (listes d'inscrits, questionnaires nominatifs) sont rangés dans un dossier à accès restreint, sur un espace de la structure, jamais sur une messagerie personnelle.

Situation	Mauvaise pratique	Bonne pratique
Un partenaire envoie ses corrections	Trois fichiers « budget_final », « budget_final2 », « budget_final_OK »	Un fichier versionné (v1, v2, v3) et un tableau des modifications
Un animateur absent doit être remplacé	Le conducteur est dans sa messagerie	Le conducteur est dans le dossier partagé, à jour
Le financeur demande un bilan intermédiaire	On reconstitue les chiffres à partir des feuilles papier	Le tableau de bord est mis à jour chaque semaine dans le tableur partagé
On doit envoyer les résultats à un partenaire	On transfère le fichier des questionnaires nominatifs	On envoie un tableau de résultats agrégés, sans nom

Définition – Compte rendu de réunion et relevé de décisions

Le **compte rendu** résume les échanges d'une réunion. Le **relevé de décisions**, plus court, ne retient que ce qui a été décidé : pour chaque décision, l'action à mener, le responsable et l'échéance. En projet, le relevé de décisions est souvent plus utile, car il se transforme directement en tâches dans le planning (8.3.6).

Exemple – Un relevé de décisions de comité de pilotage (projet fictif)

Comité de pilotage du 12 mars 2028, présents : 5 membres sur 6.

Décision	Action	Responsable	Échéance
Ouvrir un troisième créneau d'atelier le samedi matin	Réserver la salle, informer les familles de la liste d'attente	Coordinatrice	20 mars
Remplacer les flyers par une formation des relais	Organiser deux séances de formation de 2 heures	Diététicienne	15 avril
Demander une avance au financeur	Rédiger le courrier, le faire signer par la direction	Chef de projet	18 mars

Attention – Les messageries instantanées

Les groupes de messagerie sont pratiques pour rappeler un horaire, mais ils ne conviennent pas pour échanger des informations de santé, des listes nominatives ou des documents de travail : les données sortent du contrôle de la structure, et les décisions s'y perdent. On y renvoie vers le dossier partagé et vers le relevé de décisions.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.31

Votre dossier de projet contient les fichiers suivants : « questionnaire.xlsx », « questionnaire bis.xlsx », « budget définitif.xlsx », « budget définitif 2.xlsx », « photo atelier.jpg », « CR réunion.docx ». Proposez une arborescence et un nommage pour ces fichiers, et indiquez lesquels doivent être placés dans un dossier à accès restreint.

Corrigé

Arborescence possible : 03_Financement (budget), 04_Ateliers (photos), 06_Évaluation (questionnaires), 08_Pilotage (relevés de décisions). Nommage : 2028-02-03_questionnaire_avant_v1 et 2028-02-10_questionnaire_avant_v2 (ou suppression de l'ancienne version après validation) ; 2028-01-20_budget_previsionnel_v1 et 2028-03-12_budget_previsionnel_v2_VALIDÉ ; 2028-03-02_atelier1_photo_groupe ; 2028-03-12_COPIL_releve_decisions. Accès restreint : les questionnaires s'ils sont nominatifs, et la photo si des personnes sont reconnaissables (avec l'accord écrit conservé à côté).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.14 – Temps de travail et outils numériques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Une tâche est estimée à 40 h. Avec une marge de 20 %, quel temps prévoit-on ?
2. Pourquoi tenir une feuille de temps pendant le projet ?
3. À quoi sert une carte mentale dans la démarche de projet ?
4. Pourquoi écrire la date à l'envers (année-mois-jour) dans le nom d'un fichier ?
5. Quelle différence y a-t-il entre un compte rendu et un relevé de décisions ?
6. Où ranger une liste d'inscrits avec leurs coordonnées ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.14

1. 40 × 1,20 = 48 h.
2. Pour comparer le temps prévu et le temps réellement passé, ajuster le planning et nourrir le bilan.
3. À organiser des idées autour d'un thème central : brainstorming, plan du dossier, carte des partenaires.
4. Pour que les fichiers se classent automatiquement dans l'ordre chronologique.
5. Le compte rendu résume les échanges ; le relevé de décisions ne retient que les décisions, avec l'action, le responsable et l'échéance.
6. Dans un dossier à accès restreint, sur un espace de la structure, jamais sur une messagerie personnelle.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe au fil rouge 8.3.15.
3 ou 4 sur 6	Je relis la méthode d'estimation de la charge et les règles de rangement.
Moins de 3 sur 6	Je relis les parties 8.3.13 et 8.3.14 et je refais les exercices d'application.

8.3.15 Fil rouge : le plan d'action d'Inès

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès a mis en place

- **Stratégies combinées** : 6 ateliers (éducation) ; partenariat avec l'épicerie pour que les légumes secs des recettes soient disponibles à petit prix (environnement) ; mamans relais (renforcement) ; recettes du monde choisies par les familles (participation) ; note au CLS sur l'offre du quartier (plaidoyer).
- **Parties prenantes** : 14 identifiées et placées sur la matrice ; COPIL de 6 membres (direction du centre social, référente, diététicienne, CCAS-épicerie, représentante de la commune, une maman relais) réuni 3 fois (janvier, mars, juin).
- **Convention** signée avec l'épicerie solidaire (orientation des familles, fourniture des légumes secs, mention sur les supports).
- **Appel à projets ARS** : dossier déposé le 31 janvier 2028 (date limite : 15 février) ; demande de 1 500 € ; notification reçue le 2 mai ; versement en juin : le centre social a avancé les dépenses (risque R3).
- **Pilotage** : tableau de bord mis à jour chaque semaine dans le tableur ; un écart a conduit à remplacer une famille (déménagement) par une famille de la liste d'attente.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Compléments : communication, logistique et trésorerie aux Tilleuls

- **Plan de communication** : 31 familles ont pris contact pour 12 places (liste d'attente de 19 familles) ; 45 % par les mamans relais, 23 % par l'épicerie ; les 300 flyers n'ont apporté que 2 contacts : pour le cycle

suivant, le budget des flyers (45 €) finance un temps de formation des relais.

- **Méthodes** : chaque atelier combinait une courte présentation (10 minutes au plus), une démonstration du geste clé, la pratique en équipes, la dégustation et un temps de faire dire.
- **Logistique** : liste de courses calculée avec les rendements (par exemple 1,1 kg de carottes brutes pour 900 g épluchés), courses à l'épicerie solidaire et au marché, rappel des familles la veille par message vocal.
- **Trésorerie** : besoin maximal de 1 246 € fin mai ; la direction du centre social a mobilisé sa trésorerie générale ; Inès a obtenu que la commune verse sa participation dès mars.

8.4 Approfondissements

8.4.1 Le cadre logique, outil des financeurs

Niveau	Description	Indicateurs	Sources de vérification	Hypothèses
Objectif général	Contribuer à améliorer l'alimentation des familles du QPV	Consommation de légumes secs (enquête locale)	Enquête à 1 an	Contexte économique stable
Objectif spécifique	60 % des familles consomment des légumes secs ≥ 2 fois/semaine	% de familles	Questionnaire avant/après	Disponibilité à l'épicerie
Résultats	Familles capables de cuisiner 3 recettes de légumes secs	Recettes refaites déclarées	Questionnaire, échanges	Équipement de cuisine à domicile
Activités	6 ateliers, visite du marché, livret	Ateliers réalisés, présences	Émargements, livret	Locaux disponibles, financement obtenu

Le cadre logique oblige à expliciter les **hypothèses** (ce qui ne dépend pas du projet mais conditionne son succès) et les **sources de vérification** des indicateurs : il prépare directement l'évaluation (chapitre 9).

Construire un cadre logique pas à pas

Le cadre logique se construit à partir de l'**arbre à problèmes** du diagnostic (chapitre 7) : le problème central devient l'objectif spécifique, ses causes deviennent les résultats attendus, et ses conséquences renvoient à l'objectif général. On remplit ensuite la matrice **de haut en bas** pour la colonne des objectifs, puis **de bas en haut** pour vérifier la logique.

Méthode pas à pas – Remplir la matrice du cadre logique

1. Objectif général : la contribution à long terme, que le projet seul ne peut pas garantir (souvent formulée avec « contribuer à »).

2. Objectif spécifique : le changement principal attendu chez le public à la fin du projet ; il n'y en a qu'un, ou très peu.

3. Résultats : les produits concrets du projet, qui, ensemble, permettent d'atteindre l'objectif spécifique (capacités acquises, outils produits, environnement modifié).

4. Activités : ce que l'équipe fait pour obtenir chaque résultat ; on les numérote comme les résultats (activités 1.1, 1.2 pour le résultat 1).

5. Hypothèses : pour chaque niveau, les conditions extérieures nécessaires, qui ne dépendent pas du projet.

6. Indicateurs et sources : pour chaque niveau, un indicateur mesurable, une valeur cible et la source qui permettra de le vérifier.

7. Vérification de bas en haut : « si les activités sont réalisées **et** si les hypothèses se vérifient, **alors** les résultats sont obtenus ; si les résultats sont obtenus et si les hypothèses se vérifient, alors l'objectif spécifique

est atteint ».

Définition – Hypothèse et condition préalable

Une **hypothèse** est une condition extérieure au projet, nécessaire à sa réussite, que l'équipe ne maîtrise pas mais qu'elle surveille (par exemple : « l'épicerie solidaire continue à proposer des légumes secs à petit prix »). Une **condition préalable** doit être remplie avant même de commencer (par exemple : « la salle équipée est disponible »). Si une hypothèse est très peu probable et essentielle, on parle d'**hypothèse fatale** : il faut alors modifier le projet.

Exemple – De l'arbre à problèmes au cadre logique (projet fictif, résidence autonomie)

Problème central de l'arbre : « Beaucoup de résidents sautent le dîner ». Causes : isolement le soir, difficulté à cuisiner pour une personne, méconnaissance de dîners simples. Conséquences : perte de poids, risque de dénutrition.

Niveau	Contenu	Indicateur et cible	Source	Hypothèses
Objectif général	Contribuer à prévenir la dénutrition des résidents	Part des résidents ayant perdu plus de 5 % de leur poids en un an	Pesées mensuelles	Pas d'épidémie majeure pendant l'année
Objectif spécifique	Réduire de moitié la part des résidents qui sautent le dîner (de 40 % à 20 %)	Part des résidents sautant le dîner au moins 3 fois par semaine	Questionnaire avant et après	Les résidents restent dans la résidence
Résultat 1	Les résidents savent préparer trois dîners simples pour une personne	Nombre de dîners refaits déclarés	Questionnaire, échanges	Les logements disposent d'un équipement minimal
Résultat 2	Un dîner partagé mensuel est installé	Nombre de dîners organisés, participants	Émargements	La salle commune reste disponible
Activités	1.1 Six ateliers « dîners faciles » ; 1.2 livret de recettes ; 2.1 organisation des dîners avec les bénévoles	Ateliers réalisés, livret diffusé	Comptes rendus	Les bénévoles restent mobilisés

Attention – Les pièges du cadre logique

Placer une activité au niveau des objectifs (« organiser six ateliers » n'est pas un objectif spécifique) ; écrire plusieurs objectifs spécifiques sans lien entre eux ; oublier les hypothèses ; choisir des indicateurs sans source réaliste. Le cadre logique est un outil de **cohérence** : il ne remplace ni le diagnostic ni le plan d'action détaillé.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.32

Classez ces éléments dans les niveaux du cadre logique (objectif général, objectif spécifique, résultat, activité, hypothèse) : a) former deux agents à la pesée ; b) contribuer à améliorer l'état nutritionnel des résidents ; c) le service d'aide à domicile accepte de transmettre les pesées ; d) 80 % des résidents sont pesés chaque mois ; e) les agents savent repérer une perte de poids inquiétante.

Corrigé

a) Activité. b) Objectif général. c) Hypothèse (condition extérieure que l'équipe ne maîtrise pas). d) Indicateur et cible de l'objectif spécifique ou d'un résultat, selon la construction choisie : ici, on peut le lier au résultat « un suivi mensuel du poids est en place ». e) Résultat (capacité acquise grâce à la formation). On vérifie la

logique de bas en haut : si les agents sont formés (a) et si le service transmet les pesées (c), alors les agents savent repérer une perte de poids (e) et le suivi est assuré (d).

8.4.2 Le travail en réseau et la coordination territoriale

Sur un territoire, de nombreux acteurs agissent sur l'alimentation (centres sociaux, PMI, écoles, épiceries solidaires, associations, collectivités). Les **coordinations** (CLS, ateliers santé ville, PAT, réseaux régionaux de promotion de la santé comme les instances régionales d'éducation et de promotion de la santé) évitent les doublons, mutualisent les ressources et permettent un **parcours** cohérent pour les habitants. Le diététicien gagne à participer aux groupes de travail locaux : ils sont aussi une source de partenaires et de financements.

Les dispositifs de coordination à connaître

Le diététicien qui monte un projet de prévention gagne à l'inscrire dans les dispositifs existants du territoire. Il y trouve des partenaires, des données, parfois des financements, et son action a plus de chances d'être poursuivie. Le tableau présente les principaux dispositifs et leur base juridique.

Dispositif	Ce que c'est	Base juridique	Intérêt pour un projet nutrition
Contrat local de santé (CLS)	Contrat entre l'ARS et une collectivité (commune, intercommunalité) pour des actions de santé adaptées au territoire	Code de la santé publique, art. L. 1434-10	Fiches actions « alimentation » ; mise en relation avec les acteurs ; légitimité auprès des financeurs
Atelier santé ville (ASV)	Démarche de coordination santé dans les quartiers de la politique de la ville	Politique de la ville ; souvent intégré au volet santé du contrat de ville ou au CLS	Accès aux habitants des quartiers prioritaires, aux relais et aux données locales
Projet alimentaire territorial (PAT)	Projet construit par les acteurs d'un territoire pour relocaliser l'agriculture et l'alimentation	Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 ; Code rural, art. L. 111-2-2	Approvisionnement local, accessibilité alimentaire, lutte contre le gaspillage, éducation alimentaire
Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS)	Regroupement de professionnels de santé d'un territoire autour d'un projet de santé commun	Code de la santé publique, art. L. 1434-12	Missions de prévention ; lien avec les médecins, infirmiers et pharmaciens du territoire
Conseil local de santé mentale, réseaux de périnatalité, dispositifs d'appui à la coordination	Coordinations thématiques	Textes propres à chaque dispositif	Relais vers des publics spécifiques (santé mentale, périnatalité, situations complexes)

Lien avec le chapitre 7 – Le diagnostic partagé

Un CLS ou un PAT s'appuie lui-même sur un diagnostic du territoire. Avant de lancer son propre diagnostic, le diététicien consulte ces documents : ils fournissent des données et montrent quelles priorités ont déjà été retenues par les acteurs locaux.

Méthode – S'inscrire dans un dispositif territorial

1. **Repérer** les dispositifs du territoire : site de l'ARS, de la collectivité, de la préfecture (politique de la ville), de la direction régionale de l'agriculture (PAT).
2. **Lire** le document de référence (contrat, projet de santé, plan d'action du PAT) et repérer les fiches actions liées à l'alimentation.
3. **Rencontrer** le coordonnateur (coordinateur CLS, chargé de mission PAT) pour présenter le projet et

vérifier sa cohérence avec les priorités.

4. **Valoriser** ce lien dans le dossier de financement : « le projet répond à la fiche action n° 3 du CLS ».
5. **Participer** aux réunions de réseau et transmettre les résultats : c'est un gage de crédibilité et de pérennité.

Exemple – Un projet relié à trois dispositifs (projet fictif)

Une diététicienne prévoit des ateliers « cuisine de saison » dans une communauté de communes rurale. Elle découvre que le CLS comporte une fiche action « favoriser une alimentation favorable à la santé des familles », que le PAT de la communauté de communes finance l'approvisionnement des cantines en légumes locaux, et que la CPTS du territoire a inscrit la prévention du diabète dans son projet de santé. Elle construit ses ateliers avec un maraîcher du PAT, propose à la CPTS d'orienter des patients à risque, et cite la fiche action du CLS dans son dossier : trois partenaires et trois sources de légitimité pour un même projet.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.33

Pour chacune des situations suivantes, indiquez le dispositif à contacter en priorité : a) un projet d'éducation alimentaire lié aux produits des agriculteurs locaux ; b) un projet dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; c) un projet de repérage du risque de diabète avec les médecins généralistes du secteur.

Corrigé

a) Le projet alimentaire territorial (PAT), qui rassemble les producteurs, les collectivités et les acteurs de l'alimentation. b) L'atelier santé ville ou le volet santé du contrat de ville, souvent articulé avec le contrat local de santé. c) La communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), qui réunit les professionnels de santé du territoire et porte des missions de prévention. Dans les trois cas, le contrat local de santé, s'il existe, est aussi un point d'entrée utile.

8.4.3 La pérennisation dès la conception

Un projet financé sur un an risque de s'arrêter faute de moyens. La pérennisation se prépare **dès la conception** : former des relais (animatrices, mamans relais) qui pourront poursuivre l'action ; intégrer l'action dans le projet de la structure ; rechercher des financements pluriannuels (CPOM) ; produire des outils réutilisables (livret, conducteurs) ; inscrire l'action dans le CLS ou le PAT ; évaluer pour démontrer l'utilité (chapitre 9).

Les étapes de la pérennisation

Pérenniser ne veut pas dire répéter le même projet à l'identique, avec les mêmes financements. C'est faire en sorte que **les effets** et **les compétences** acquises durent, et que l'action, éventuellement transformée, soit **portée par d'autres** quand le financement initial s'arrête.

Étape	Moment	Actions
1. Prévoir	Dès la conception	Identifier qui pourra poursuivre l'action ; prévoir la formation de relais ; choisir des activités peu coûteuses à reconduire
2. Transférer	Pendant le projet	Associer les relais à l'animation ; rédiger des outils réutilisables (conducteurs, livret, fiches recettes) ; documenter les choix
3. Démontrer	Fin du projet	Évaluer les résultats et les coûts ; présenter le bilan aux décideurs ; proposer des scénarios de suite chiffrés
4. Intégrer	Après le projet	Inscrire l'action dans le projet de la structure, dans un CLS ou un PAT ; rechercher un financement pluriannuel

Définition – Transférabilité

Capacité d'une action à être reproduite dans un autre lieu ou par d'autres intervenants, avec des résultats comparables. Elle suppose une description précise de l'action (objectifs, public, contenu des séances, moyens) et l'identification de ses **fonctions clés**, c'est-à-dire de ce qui doit être conservé pour que l'action reste efficace (8.3.1).

Exemple – Trois scénarios de suite chiffrés (projet fictif)

À la fin d'un cycle de 6 ateliers qui a coûté 3 060 € en dépenses monétaires, la diététicienne présente trois scénarios au comité de pilotage :

- **Scénario 1, reconduction à l'identique** : 3 060 € par an, financement à trouver en totalité.
- **Scénario 2, animation par deux relais formées, avec deux interventions de la diététicienne** : 2 × 3 h × 45 € = 270 € d'honoraires, plus les denrées et le petit matériel (environ 600 €), soit environ 870 € par an.
- **Scénario 3, intégration au programme du centre social** : les ateliers sont animés par l'animatrice salariée du centre ; seules les denrées sont à financer.

Le comité retient le scénario 2 pour un an, avec une évaluation à mi-parcours : il maintient l'expertise diététique tout en divisant le coût par plus de trois (3 060 / 870 = 3,5).

Attention – La dépendance à une seule personne

Un projet qui repose entièrement sur une personne (stagiaire, salarié en contrat court, bénévole très investi) s'arrête souvent avec son départ. La passation (documents, contacts, relevés de décisions) et la formation d'au moins deux relais sont des conditions de la pérennisation.

8.4.4 Les contrats pluriannuels et les fonds européens

Pour pérenniser une action, les structures cherchent des financements **pluriannuels** : contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) avec l'ARS, conventions pluriannuelles avec les collectivités, financements de la CAF (prestations de service). Les **fonds européens** (Fonds social européen plus, FSE+, programmes régionaux) peuvent financer des projets d'inclusion ou d'aide alimentaire (une partie de l'aide alimentaire européenne relève du FSE+), avec des exigences administratives importantes (justificatifs, suivi des participants). Un projet de stage ne mobilise généralement pas ces fonds, mais le diététicien en poste peut y contribuer.

Les exigences des financements pluriannuels et européens

Les financements pluriannuels sécurisent une action, mais ils demandent une gestion plus rigoureuse. Le chef de projet doit les connaître pour éviter de s'engager dans un financement que la structure ne pourra pas gérer.

Exigence	Ce qu'elle implique	Conséquence pour la structure
Objectifs et indicateurs sur plusieurs années	Un dialogue de gestion annuel avec le financeur, sur la base des indicateurs	Disposer d'un tableau de bord fiable et d'une évaluation continue
Justification des dépenses	Factures, feuilles de temps, preuves de publicité du soutien	Archiver les pièces pendant la durée exigée par le financeur
Versements différés	Souvent un acompte, puis des versements après contrôle des justificatifs	Prévoir un plan de trésorerie sur toute la durée (8.3.10)
Cofinancement	Une part du budget doit venir d'autres financeurs	Rechercher plusieurs financeurs en même temps
Contrôle	Contrôle sur pièces ou sur place ; reversement des sommes non justifiées	Organiser les dossiers dès le début du projet

Attention – Les fonds européens demandent une structure solide

Le Fonds social européen Plus (FSE+, programmation 2021-2027) peut financer des actions d'inclusion sociale, y compris en lien avec l'alimentation. Mais les dossiers sont lourds, les versements interviennent souvent longtemps après les dépenses et les contrôles sont stricts. Une petite association a intérêt à passer par une structure intermédiaire ou à commencer par des financements plus simples (commune, CAF, fondations, ARS).

À vous de jouer – Exercice d'application 8.34

Une association reçoit une proposition de financement sur trois ans : 6 000 € par an, avec un acompte de 30 % au début de chaque année et le solde après justification des dépenses, environ six mois après la fin de l'année. Calculez l'acompte et le solde annuels, puis expliquez la conséquence pour la trésorerie de l'association.

Corrigé

Acompte : 6 000 × 0,30 = 1 800 € au début de chaque année. Solde : 6 000 − 1 800 = 4 200 €, versé environ six mois après la fin de l'année. L'association doit donc avancer 4 200 € de dépenses chaque année, et pendant six mois de plus le temps du versement. Au début de la deuxième année, elle reçoit l'acompte de la deuxième année alors que le solde de la première n'est pas encore versé : elle doit avoir une trésorerie suffisante ou négocier un calendrier de versement plus favorable, et suivre un plan de trésorerie sur les trois ans.

8.4.5 La gestion des bénévoles

De nombreux projets reposent sur des **bénévoles** (aide en cuisine, accueil, mamans relais). Leur engagement est précieux mais fragile : il suppose un **accueil** (présentation du projet, des règles d'hygiène et de confidentialité), un **rôle clair** (fiche de mission), une **formation** courte, une **reconnaissance** (remerciements, attestation, participation aux temps forts) et un **suivi** (points réguliers). Le bénévolat se valorise dans le budget (comptes 86 et

87. et se distingue du travail salarié : pas de lien de subordination ni de rémunération.

Accueillir des bénévoles : cadre pratique

Les bénévoles apportent du temps, des compétences et un lien avec les habitants. Leur place doit être organisée : un bénévole mal accueilli ou sans rôle précis s'en va ; un bénévole mal assuré expose la structure à des risques.

Question	Réponse pratique
Faut-il un contrat ?	Non : le bénévolat ne crée pas de lien de subordination. On utilise une **fiche de mission** et, souvent, une **charte du bénévole** signée (valeurs, confidentialité, règles d'hygiène).
Les bénévoles sont-ils assurés ?	La structure vérifie que son contrat d'assurance couvre la responsabilité civile et les accidents des bénévoles pendant les activités, y compris les trajets si nécessaire.
Peut-on les rembourser ?	Oui, les frais réellement engagés pour l'association (achats, déplacements) peuvent être remboursés sur justificatifs. Un remboursement forfaitaire sans justificatif risque d'être considéré comme une rémunération.
Que se passe-t-il s'ils renoncent au remboursement ?	Les frais engagés et non remboursés peuvent être considérés comme un **don** à une association d'intérêt général : ils ouvrent droit à une réduction d'impôt (article 200 du Code général des impôts).

Question	Réponse pratique
Comment valoriser leur temps ?	Dans les contributions volontaires en nature du budget (8.3.5), avec un taux horaire justifié.

Exemple – Calcul détaillé : l'abandon de frais d'une bénévole

Une bénévole a engagé 300 € de frais justifiés (achats de denrées et déplacements) pour une association d'intérêt général, qui a constaté ces frais dans ses comptes. Elle renonce par écrit à leur remboursement. L'association lui délivre un reçu fiscal de 300 €. La réduction d'impôt est de 66 % du montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable : 300 × 0,66 = **198 €**. Le coût réel pour la bénévole est de 300 − 198 = **102 €**.

Méthode – Rédiger une fiche de mission de bénévole

1. **Intitulé** de la mission (« aide en cuisine lors des ateliers du jeudi »).
2. **Objectif** de la mission dans le projet.
3. **Activités** confiées, et ce qui n'est pas confié (par exemple : pas de conseil nutritionnel individuel).
4. **Disponibilité** attendue (jour, horaire, fréquence) et durée de l'engagement.
5. **Formation** et accompagnement prévus (hygiène, confidentialité, posture d'écoute).
6. **Référent** de la structure, à contacter en cas de question.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.35

Un bénévole demande à recevoir 20 € par atelier « pour ses frais », sans justificatif. Expliquez pourquoi la structure refuse, puis proposez deux solutions conformes.

Corrigé

Un versement forfaitaire sans justificatif peut être considéré comme une rémunération : le bénévole deviendrait un salarié de fait, avec des obligations sociales pour la structure, et le caractère bénévole serait remis en cause. Solutions : rembourser les frais réels sur présentation de justificatifs (tickets de caisse, trajets déclarés selon les règles de la structure) ; ou proposer au bénévole d'abandonner le remboursement de ses frais justifiés et de recevoir un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d'impôt de 66 %.

8.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Gestion de projet : méthodes prédictives et agiles

La planification présentée (Gantt, PERT) relève des méthodes **prédictives** : on fixe le plan au départ. Les méthodes **agiles** (issues de l'informatique, manifeste agile de 2001) procèdent par **itérations** courtes, avec des retours fréquents des utilisateurs et des ajustements continus. En santé publique, une approche « hybride » est fréquente : un cadre fixé (objectifs, budget, calendrier du financeur) et des séances ajustées après chaque retour des participants (cycle « planifier, faire, vérifier, agir » de Deming, ou PDCA).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Coût, efficience et analyse médico-économique

L'**efficience** rapporte les résultats obtenus aux ressources mobilisées. Les évaluations médico-économiques comparent des interventions : analyse coût-efficacité (coût par unité de résultat, par exemple coût par famille ayant atteint l'objectif), coût-utilité (coût par année de vie ajustée sur la qualité, QALY), coût-bénéfice (résultats exprimés en euros). Exemple simple : si 9 familles sur 12 atteignent l'objectif « légumes secs », le

coût par famille ayant atteint l'objectif est de 3 510 / 9 = **390 €**. Ces calculs restent fragiles à petite échelle, mais ils intéressent de plus en plus les financeurs.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Sociologie de la traduction et partenariats

La **sociologie de la traduction** (Callon, Latour, années 1980) analyse la manière dont un projet « enrôle » des acteurs aux intérêts différents en traduisant le problème dans les termes de chacun (pour l'épicerie : écouler des produits ; pour l'école : associer les parents ; pour l'ARS : réduire les inégalités). Un porteur de projet efficace construit des « points de passage obligés » où les intérêts convergent.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Évaluer le coût d'opportunité et le retour social sur investissement

Le **coût d'opportunité** d'un projet est la valeur de la meilleure alternative à laquelle on renonce en y consacrant des ressources (le temps de la diététicienne aurait pu servir à des consultations). Le **retour social sur investissement** (SROI) tente de traduire en valeur monétaire les effets sociaux d'un projet (économies de santé, gain de qualité de vie, réduction du gaspillage) et de les rapporter à l'investissement : un ratio de 3 signifie 3 € de valeur sociale créée pour 1 € investi. La méthode est discutée (choix des valeurs, attribution des effets), mais elle oblige à expliciter la **chaîne des effets** attendus et intéresse les financeurs.

8.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Du soin au collectif

Un diététicien libéral, constatant les besoins de ses patients diabétiques, monte avec une maison de santé un programme d'ateliers collectifs financé par l'ARS ; il rédige la réponse à l'appel à projets et un budget incluant ses honoraires d'animation.

Situation bc2 – Budget et restauration

En restauration collective, le diététicien prépare le budget d'une animation « semaine du goût » (denrées, supports, temps de personnel) et suit les écarts entre prévu et réalisé, avec les mêmes outils qu'un projet BC3.

Situation bc3 – Une demande à la conférence des financeurs

Un CCAS sollicite la conférence des financeurs pour des ateliers « bien manger après 60 ans » : le diététicien lit le cahier des charges, vérifie l'éligibilité (public de 60 ans et plus, territoire), adapte les objectifs et construit le budget.

Situation bc3 – Un projet en retard

À mi-parcours, seules 2 des 4 écoles prévues ont commencé les ateliers. Le diététicien analyse les causes (calendrier scolaire, changement de directeur), réunit le COPIL, propose un nouveau calendrier et informe le financeur.

Situation bc3 – Une communication qui ne touche pas le public

Après trois semaines, un atelier n'a que 3 inscrits malgré 500 flyers distribués. Le diététicien analyse les canaux, rencontre l'animatrice du centre social et une association de quartier, forme deux habitantes relais : 11 inscriptions en une semaine.

Situation bc3 – Une subvention versée tardivement

Un projet financé par une fondation doit avancer 2 000 € d'achats avant le versement. Le diététicien établit un plan de trésorerie, propose à la direction un échelonnement des achats et demande un acompte de 30 % au financeur.

Cas guidé : un tiers-lieu nourricier en milieu rural

Ce cas guidé reprend toutes les étapes du chapitre sur un projet complet. Lisez la situation, essayez de répondre à chaque question, puis lisez la réponse commentée. Les données sont **fictives**.

Document – La situation

La commune de Saint-Aubin-des-Prés compte 1 900 habitants ; le supermarché le plus proche est à 14 km, et le bus ne passe que deux fois par jour. Une association a ouvert dans une ancienne grange un **tiers-lieu** : café associatif, atelier de réparation, cuisine partagée équipée. Un maraîcher bio s'est installé à 3 km. L'association souhaite monter un projet « Cuisiner ensemble à la Grange » pour deux publics : les personnes de plus de 65 ans qui vivent seules (environ 180 dans la commune) et les parents de jeunes enfants. Une enquête menée par l'association auprès de 64 habitants en 2027 indique que 47 % des plus de 65 ans interrogés mangent seuls tous les soirs et que 38 % des parents déclarent « ne pas savoir quoi cuisiner avec des légumes de saison ». Vous êtes diététicien et vous accompagnez l'association.

Étape 1 – Choisir les stratégies. Quelles stratégies combiner, et pourquoi ?

Réponse commentée – Étape 1

On combine au moins trois stratégies (8.3.1). L'**éducation** : des ateliers culinaires de saison. L'action sur l'**environnement** : un accès facilité aux légumes du maraîcher (paniers à prix solidaire, dépôt à la Grange) et un transport solidaire pour les personnes âgées sans voiture. Le **lien social et la participation** : des repas partagés intergénérationnels, des recettes choisies par les participants. Le diagnostic montre en effet un problème d'accès (distance, transport), de savoir-faire et d'isolement : une seule stratégie ne suffirait pas.

Étape 2 – Formuler un objectif spécifique et deux objectifs opérationnels.

Réponse commentée – Étape 2

Objectif spécifique : « D'ici juin 2028, la moitié des participants au moins déclarent préparer un repas avec des légumes de saison au moins trois fois par semaine. » Objectifs opérationnels : « Organiser 8 ateliers culinaires de 12 participants entre octobre 2027 et mai 2028, avec au moins un tiers de personnes de plus de 65 ans » ; « Mettre en place un dépôt hebdomadaire de paniers du maraîcher à la Grange à partir de novembre 2027 ». Chaque objectif est mesurable, daté et réaliste.

Étape 3 – Identifier les parties prenantes. Citez cinq partenaires et leur rôle.

Réponse commentée – Étape 3

L'association du tiers-lieu (porteur, locaux, bénévoles) ; le maraîcher (produits, visite de l'exploitation, prix solidaire) ; la commune (financement, communication par le bulletin municipal, transport solidaire) ; le CCAS ou le service d'aide à domicile (repérage des personnes âgées isolées) ; la PMI ou le relais petite enfance (repérage des parents). On peut ajouter le projet alimentaire territorial de la communauté de communes, s'il

existe (8.4.2), et le centre de ressources du réseau Promotion Santé pour les outils.

Étape 4 – Construire le budget prévisionnel. Données : diététicienne 8 ateliers × 4 h × 45 € ; denrées 8 ateliers × 12 portions × 2,10 € ; petit matériel 650 € ; communication 180 € ; transport solidaire 8 × 35 € ; assurance complémentaire 120 €. Contributions en nature : 3 bénévoles × 3 h × 8 ateliers au taux de 13 € de l'heure (taux fictif) ; cuisine de la Grange, valeur locative 40 € par atelier ; légumes donnés par le maraîcher, 15 € par atelier. Recettes : ARS 1 500 € ; commune 600 € ; fondation 600 € ; participation de 1 € par participant et par atelier.

Réponse commentée – Étape 4

Charges monétaires : diététicienne 8 × 4 × 45 = **1 440 €** ; denrées 8 × 12 × 2,10 = **201,60 €** ; petit matériel **650 €** ; communication **180 €** ; transport 8 × 35 = **280 €** ; assurance **120 €**. Total monétaire : 1 440 + 201,60 + 650 + 180 + 280 + 120 = **2 871,60 €**.

Contributions en nature : bénévoles 3 × 3 × 8 × 13 = **936 €** ; cuisine 8 × 40 = **320 €** ; légumes 8 × 15 = **120 €** ; total **1 376 €**.

Total des charges : 2 871,60 + 1 376 = **4 247,60 €**.

Recettes monétaires : 1 500 + 600 + 600 + 96 (8 × 12 × 1 €) = **2 796 €**. Autofinancement de l'association : 2 871,60 − 2 796 = **75,60 €**. Le budget s'équilibre à 4 247,60 € en ajoutant les 1 376 € de contributions en nature aux recettes (comptes 86 et 87).

Ratios : l'ARS finance 1 500 / 4 247,60 = **35,3 %** du budget total ; les contributions en nature représentent 1 376 / 4 247,60 = **32,4 %** du total, ce qui montre l'importance de l'engagement local. Coût monétaire par participation : 2 871,60 / 96 = **29,91 €**.

Étape 5 – Choisir trois indicateurs de suivi.

Réponse commentée – Étape 5

Un indicateur de **réalisation** : nombre d'ateliers réalisés sur 8 prévus. Un indicateur de **participation** : taux de présence (présences / places proposées). Par exemple, avec 12, 11, 12, 10, 9, 12, 11 et 12 présents, on obtient 89 présences sur 96 places, soit 89 / 96 = **92,7 %**. Un indicateur de **résultat** : part des participants déclarant cuisiner des légumes de saison au moins trois fois par semaine, mesurée par un questionnaire avant et après. On peut ajouter un indicateur sur l'environnement : nombre de paniers vendus chaque semaine au dépôt.

Étape 6 – Repérer deux risques et prévoir leur traitement.

Réponse commentée – Étape 6

Risque 1 : les personnes âgées ne viennent pas faute de transport (probabilité élevée, impact fort). Traitement : transport solidaire organisé avec la commune, inscription par téléphone, rappel la veille. Risque 2 : le financement de l'ARS est notifié tardivement, alors que les achats de matériel ont lieu en octobre (probabilité moyenne, impact moyen). Traitement : plan de trésorerie, demande d'acompte, achat progressif du matériel (8.3.10). On peut aussi citer le risque sanitaire en cuisine partagée (formation hygiène des bénévoles, fiche allergies, 8.3.9).

Étape 7 – Préparer la pérennisation.

Réponse commentée – Étape 7

Former deux bénévoles du tiers-lieu à l'animation d'ateliers simples, avec un livret de recettes de saison construit avec les participants ; présenter le bilan à la commune et au projet alimentaire territorial ; proposer pour l'année suivante un scénario où la diététicienne n'intervient plus qu'à deux ateliers sur huit, et où le dépôt de paniers devient autonome (8.4.3).

Ce que le jury attend sur la conception et le pilotage

À l'épreuve E5, le jury ne vérifie pas seulement que vous connaissez les outils : il vérifie que vous savez les **choisir**, les **justifier** et les **adapter** à votre projet. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes et la manière d'y répondre.

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Un lien clair entre le diagnostic et le plan d'action	Chaque action renvoie à une cause identifiée dans l'arbre à problèmes	Des actions choisies « parce que ça marche bien » sans lien avec les constats
Des objectifs bien formulés	Des objectifs mesurables, datés, avec des indicateurs et des cibles	Des objectifs vagues ou confondus avec des activités
Des stratégies combinées	Au moins une action sur l'environnement en plus de l'éducation	Uniquement des ateliers d'information
Un partenariat réel	Des partenaires nommés, avec un rôle précis et un accord écrit	Une liste de structures « à contacter »
Un budget juste et expliqué	Des calculs détaillés, des contributions en nature valorisées, un budget équilibré	Des montants ronds sans justification, un budget déséquilibré
Un pilotage effectif	Un tableau de bord, des écarts repérés, des décisions prises	Un planning théorique jamais confronté au réalisé
Une posture réflexive	Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que vous changeriez	Un récit sans analyse critique
Le respect de l'éthique	Messages non stigmatisants, consentement, données protégées, absence de conflit d'intérêts	Photos sans accord, outils sponsorisés par une marque

Astuce – Une phrase de justification par choix

Pour chaque choix important (stratégie, méthode, outil, partenaire, indicateur), écrivez une phrase qui commence par « J'ai choisi… parce que… ». Elle oblige à relier le choix au diagnostic, au public ou aux contraintes, et c'est exactement ce que le jury cherche à l'oral.

Erreurs fréquentes – Conception et pilotage du projet

- **Confondre objectif et activité** : « organiser six ateliers » est une activité ; l'objectif dit ce qui change chez le public.
- **Oublier le rendement et le conditionnement** dans les quantités, ce qui fausse les courses et le budget.
- **Mélanger budget et trésorerie** : un budget équilibré n'empêche pas un manque d'argent en cours de projet ; les contributions en nature n'entrent pas dans le plan de trésorerie.
- **Calculer un chemin critique sans vérifier les dépendances** : une tâche oubliée peut changer la durée totale du projet.
- **Négliger le temps** : le temps de préparation, de réunion et de saisie est souvent sous-estimé de moitié ; une marge de 15 à 25 % est prudente.
- **Citer des partenaires sans engagement écrit**, ou accepter un partenaire commercial sans analyser le conflit d'intérêts.
- **Utiliser des messages stigmatisants** (« obèses », « mauvaises habitudes ») ou des images de personnes sans accord écrit.
- **Oublier l'hygiène et les allergènes** dans un atelier culinaire ou un buffet de fin de projet.
- **Ne pas prévoir la suite** : un projet sans relais formé ni scénario de pérennisation s'arrête avec son financement.

8.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Concevoir le plan d'action

- **Combiner les stratégies** : éducation + environnement + lien social + participation + plaidoyer + formation de relais.
- **Choisir une action** : cohérence, efficacité (données probantes), adaptation, faisabilité, acceptabilité, éthique.
- **QQOQCCP** : quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi ; **fiche projet** (F4).
- **Parties prenantes** : matrice pouvoir/intérêt (gérer étroitement, satisfaire, associer, surveiller) ; **RACI** (réalise, approuve, consulté, informé) ; **convention** ; **COPIL** (décide) / comité technique (organise) / comité d'usagers.
- **Financeurs** : ARS (FIR, art. L. 1435-8 CSP), collectivités, CAF, conférence des financeurs (loi du 28 décembre 2015), assurance maladie, mutuelles, fondations ; **appel à projets** : lire le cahier des charges, éligibilité, correspondance aux priorités, dossier complet (Cerfa n° 12156), dépôt avant la date limite, bilan.

À retenir – Planifier, budgéter, piloter

- **Gantt** : tâches × temps, jalons, dépendances. **PERT** : dates au plus tôt (max des fins des antériorités), au plus tard (min des débuts suivants), **marge** = au plus tard − au plus tôt ; **chemin critique** = tâches à marge nulle.
- **Budget** : charges (60, 61-62, 64, 86) = produits (70, 74, 75, 87) ; 86 = 87 ; cofinancement ; quantité × coût unitaire ; coût horaire = coût employeur / heures (151,67 h par mois).
- **Ratios** : part d'un financeur, part du personnel, coût par participant, coût par heure.
- **Écarts** : réalisé − prévu ; écart / prévu × 100 ; expliquer les écarts.
- **Pilotage** : tableau de bord (activité, présence, budget, délais) ; **risques** : criticité = probabilité × gravité ; réunion avec ordre du jour, décisions et relevé d'actions.

À retenir – Compléments : communication, pédagogie, logistique, trésorerie, dossier

- **Plan de communication** (F10) : objectifs, cibles, messages, canaux et supports, calendrier, budget et évaluation ; relais humains souvent plus efficaces que les supports ; coût par contact.
- **Méthodes pédagogiques** : expositive, interrogative, démonstrative, active, coopérative ; choisir selon le type d'objectif ; la « pyramide de l'apprentissage » est un mythe.
- **Logistique** : quantité brute = quantité nette × coefficient / rendement ; check-list avant, jour J, après.
- **Trésorerie** : solde = solde précédent + encaissements − décaissements ; besoin maximal ; acompte, échelonnement.
- **Dossier de financement** : constats chiffrés, politiques, objectifs SMART, actions, participation, évaluation, budget cofinancé, pérennisation.

8.8 Entraînement

8.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Une action sur l'environnement alimentaire :

a) mettre l'eau en carafe à la cantine **b)** une conférence sur le sucre **c)** un partenariat avec une épicerie solidaire **d)** un quiz sur les repères

QCM 2 – La méthode QQOQCCP permet :

a) de décrire précisément une action **b)** de calculer un budget **c)** de vérifier qu'aucune dimension n'est oubliée **d)** de prioriser des problèmes

QCM 3 – Dans la matrice pouvoir/intérêt, les familles du public :

a) ont généralement un intérêt fort **b)** sont à associer et tenir informées **c)** sont à surveiller seulement **d)** peuvent siéger dans un comité d'usagers

QCM 4 – Dans une matrice RACI :

a) R = réalise **b)** A = approuve (une seule personne par tâche) **c)** C = contrôle **d)** I = informé

QCM 5 – Le comité de pilotage :

a) décide des orientations **b)** se réunit chaque jour **c)** valide les étapes et le budget **d)** peut inclure des usagers

QCM 6 – Le fonds d'intervention régional :

a) est géré par l'ARS **b)** finance des actions de prévention **c)** est prévu par le Code de la santé publique **d)** est réservé aux hôpitaux

QCM 7 – La conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie :

a) concerne les 60 ans et plus **b)** a été créée par la loi du 28 décembre 2015 **c)** finance les crèches **d)** lance des appels à projets départementaux

QCM 8 – Le chemin critique :

a) est la suite de tâches sans marge **b)** détermine la durée minimale du projet **c)** contient les tâches les moins importantes **d)** se calcule avec un réseau PERT

QCM 9 – Si A dure 2 semaines, B 3 semaines (après A) et C 4 semaines (après A), et D (2 semaines) suit B et C, la durée minimale est :

a) 7 semaines **b)** 8 semaines **c)** 11 semaines **d)** 9 semaines

QCM 10 – Un budget prévisionnel associatif :

a) doit être équilibré **b)** présente les contributions en nature aux comptes 86 et 87 **c)** peut être financé à 100 % par un seul financeur sans difficulté **d)** distingue charges et produits

QCM 11 – Les charges de personnel figurent au compte :

a) 60 **b)** 62 **c)** 64 **d)** 74

QCM 12 – Une subvention de l'ARS figure au compte :

a) 70 **b)** 74 **c)** 86 **d)** 87

QCM 13 – Un poste prévu à 400 € et réalisé à 460 € présente un écart de :

a) + 60 € **b)** + 15 % **c)** + 13 % **d)** − 60 €

QCM 14 – Dans une matrice des risques, la criticité :

a) = probabilité × gravité **b)** = probabilité + gravité **c)** permet de hiérarchiser les risques **d)** dispense de traiter les risques graves peu probables

QCM 15 – Le compte rendu d'une réunion de pilotage contient :

a) les présents et excusés **b)** les décisions prises **c)** le relevé des actions (qui, quoi, quand) **d)** la retranscription mot à mot des échanges

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, c. 2. **a, c**. 3. **a, b, d**. 4. **a, b, d**. 5. **a, c, d**. 6. **a, b, c**. 7. **a, b, d**. 8. **a, b, d**. 9. **b** (A 2 + max(B 3 ; C 4) + D 2 = 2 + 4 + 2 = 8). 10. **a, b, d**. 11. **c**. 12. **b**. 13. **a, b** (60 / 400 × 100 = 15 %). 14. **a, c**. 15. **a, b, c**.

QCM 16 – Un plan de communication précise :

a) les cibles **b)** les messages **c)** les canaux et le calendrier **d)** les valeurs nutritionnelles des recettes

QCM 17 – Pour obtenir 900 g de carottes épluchées avec un rendement de 85 %, il faut acheter environ :

a) 765 g **b)** 900 g **c)** 1 059 g **d)** 1 500 g

QCM 18 – Un problème de trésorerie peut survenir :

a) même si le budget est équilibré **b)** quand les subventions sont versées après les dépenses **c)** uniquement si le budget est déficitaire **d)** quand le solde mensuel devient négatif

QCM 19 – Une méthode démonstrative :

a) consiste à montrer un geste puis à le faire reproduire **b)** convient aux savoir-faire **c)** se limite à un exposé **d)** peut être utilisée pour la cuisson des légumes secs

QCM 20 – Les bénévoles d'un projet :

a) sont valorisés aux comptes 86 et 87 **b)** sont rémunérés **c)** ont besoin d'une mission claire et d'une reconnaissance **d)** ne sont pas concernés par les règles d'hygiène

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM complémentaires

16. a, b, c. 17. **c** (900 / 0,85). 18. **a, b, d**. 19. **a, b, d**. 20. **a, c**.

8.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : la matrice pouvoir/intérêt

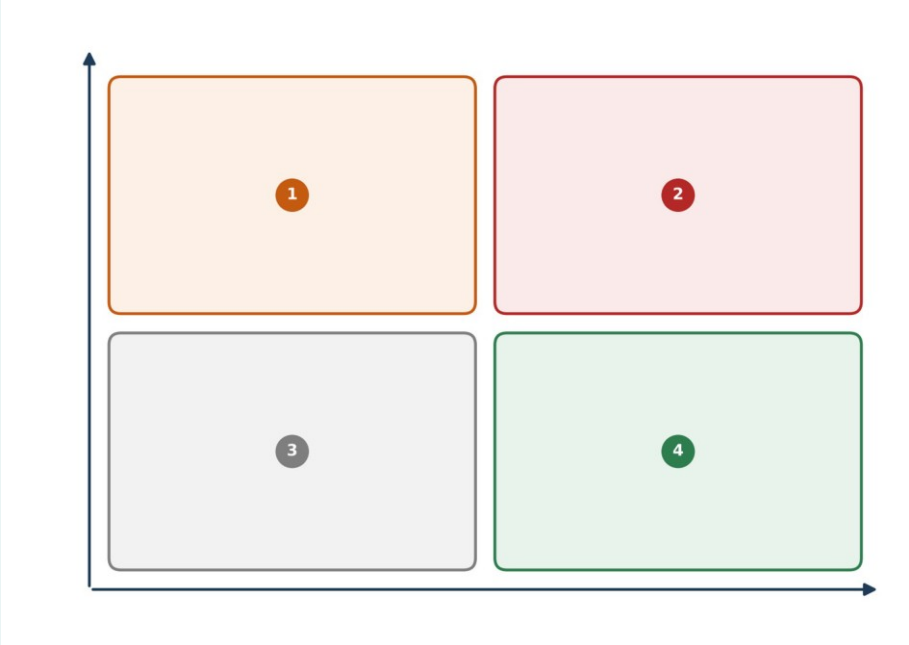


Figure 8.6 – Schéma à légender

Nommez les quadrants 1 à 4 (stratégie à adopter) et placez : a) le maire adjoint à la santé ; b) les parents d'élèves ; c) l'ARS ; d) la boulangerie du quartier ; e) la directrice de l'école partenaire.

Corrigé

1. Satisfaire (pouvoir fort, intérêt faible) : a) le maire adjoint (s'il ne suit pas le projet de près). 2. **Gérer étroitement** : c) l'ARS (financeur) ; e) la directrice de l'école (si l'action s'y déroule). 3. **Surveiller** : d) la boulangerie. 4. **Associer, tenir informés** : b) les parents. Le placement peut varier selon le contexte : il se justifie.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : la matrice des risques

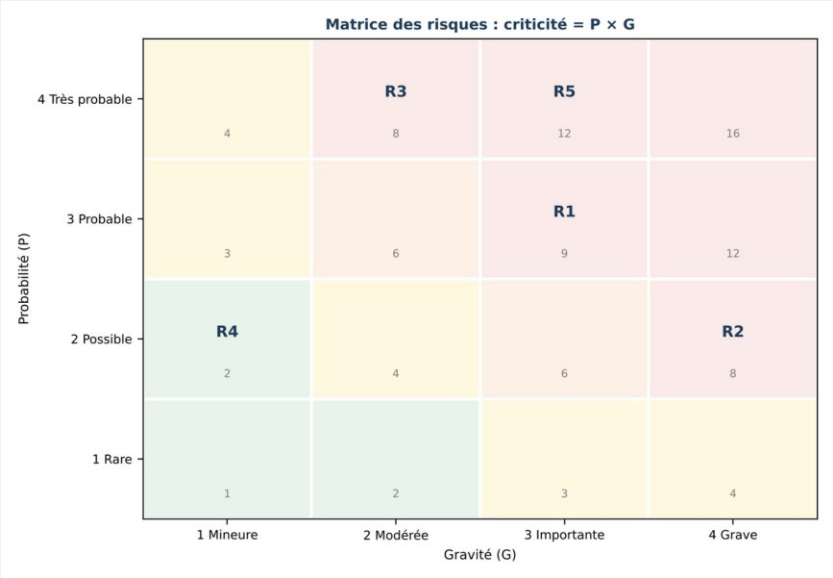


Figure 8.7 – Schéma à légender

Identifiez les risques R1 à R5 placés sur la matrice (probabilité, gravité), calculez leur criticité et classez-les.

Corrigé

R1 (P 3, G 3) = **9** ; R2 (P 2, G 4) = **8** ; R3 (P 4, G 2) = **8** ; R4 (P 2, G 1) = **2** ; R5 (P 4, G 3) = **12**. Classement : R5 > R1 > R2 = R3 > R4. R2 (allergie), grave, est traité en priorité malgré sa probabilité moyenne.

À vous de jouer – Exercice 3 – Réseau PERT

Un projet comprend : A recrutement des participants (2 sem.) ; B formation des animateurs (3 sem.) ; C préparation des supports (2 sem., après B) ; D atelier pilote (1 sem., après A et C) ; E ajustements (1 sem., après D) ; F cycle d'ateliers (8 sem., après E). Calculez les dates au plus tôt, la durée minimale, le chemin critique et la marge de A.

Corrigé

A : 0 → 2. B : 0 → 3. C : 3 → 5. D : début max(2 ; 5) = 5 → 6. E : 6 → 7. F : 7 → **15**. Durée minimale : **15 semaines**. Chemin critique : **B → C → D → E → F** (3 + 2 + 1 + 1 + 8 = 15). A : au plus tard, doit finir à 5 (début de D), donc commencer à 3 ; marge = 3 − 0 = **3 semaines**.

À vous de jouer – Exercice 4 – Construire un budget prévisionnel

Construisez le budget équilibré d'un cycle de 8 ateliers pour 10 seniors : denrées 2,50 € par personne et par atelier ; diététicienne 8 ateliers × 3 h à 40 €/h ; supports 120 € ; assurance 60 € ; salle prêtée par la mairie (valorisée 25 € par atelier) ; bénévolat 16 h à 12 €/h. Produits : conférence des financeurs 1 200 € ; caisse de retraite 400 € ; participation 1 € par personne et par atelier.

Corrigé

Charges : denrées 2,50 × 10 × 8 = **200 €** ; diététicienne 8 × 3 × 40 = **960 €** ; supports **120 €** ; assurance **60 €** ; salle (86) 25 × 8 = **200 €** ; bénévolat (86) 16 × 12 = **192 €** ; total = 200 + 960 + 120 + 60 + 200 + 192 = **1 732 €**. **Produits** : conférence des financeurs **1 200 €** ; caisse de retraite **400 €** ; participation 1 × 10 × 8 = **80 €** ; contributions en nature (87) 200 + 192 = **392 €** ; sous-total = 1 200 + 400 + 80 + 392 = 2 072 €. **Constat** : les produits dépassent les charges de 2 072 − 1 732 = **340 €** : le budget n'est pas équilibré. Il faut **réduire la demande** à la conférence des financeurs à 1 200 − 340 = **860 €** (ou ajouter des charges justifiées, par exemple du temps de coordination). Budget équilibré : 1 732 € = 860 + 400 + 80 + 392.

À vous de jouer – Exercice 5 – Calculer un coût horaire

Une animatrice est payée 1 900 € bruts par mois ; la structure indique un taux de charges patronales de 40 %. Calculez son coût horaire et le coût de 25 h consacrées au projet.

Corrigé

Coût employeur : 1 900 × 1,40 = **2 660 €** ; heures mensuelles : 151,67 ; coût horaire : 2 660 / 151,67 = **17,54 €** ; 25 h : 25 × 17,54 = **438,50 €**.

À vous de jouer – Exercice 6 – Analyser des écarts

Prévu / réalisé : denrées 300 / 342 ; impression 150 / 120 ; intervenant 800 / 800 ; déplacements 100 / 64. Calculez les écarts en euros et en pourcentage, le total, et commentez.

Corrigé

Denrées : + 42 € ; 42 / 300 × 100 = **+ 14,0 %**. Impression : − 30 € ; − 30 / 150 × 100 = **− 20,0 %**. Intervenant : **0**. Déplacements : − 36 € ; − 36 / 100 × 100 = **− 36,0 %**. Total prévu : 300 + 150 + 800 + 100 = **1 350 €** ; réalisé : 342 + 120 + 800 + 64 = **1 326 €** ; écart : − 24 €, soit − 24 / 1 350 × 100 = **− 1,8 %**. Commentaire : budget respecté globalement ; hausse des denrées (prix, participants supplémentaires ?) compensée par les économies d'impression et de déplacements ; écarts à expliquer dans le compte rendu financier.

À vous de jouer – Exercice 7 – Lire un cahier des charges

Extrait d'un appel à projets ARS : « Publics prioritaires : enfants de 0 à 6 ans et leurs parents résidant en QPV ; actions de plus de 3 séances ; cofinancement obligatoire ; montant maximal 5 000 € et 70 % du coût total ; exclus : actions ponctuelles, achat de matériel au-delà de 10 % du budget. » Un projet de 6 ateliers pour des parents d'enfants de 3 à 10 ans d'un QPV coûte 4 800 €, dont 700 € de matériel. Vérifiez l'éligibilité et calculez le montant maximal sollicitable.

Corrigé

Public : enfants de 3 à 10 ans → **partiellement** hors cible (0-6 ans) : recentrer sur les parents d'enfants de 3 à 6 ans ou justifier. Nombre de séances : 6 > 3 . Matériel : 700 / 4 800 × 100 = **14,6 %** > 10 % → **non conforme** : ramener le matériel à 480 € au plus (10 % × 4 800). Montant maximal : 70 % × 4 800 = **3 360 €** (< 5 000 €) ;

cofinancement minimal : 4 800 − 3 360 = **1 440 €**.

À vous de jouer – Exercice 8 – Rédiger une fiche action avec le QQOQCCP

Rédigez la fiche action d'une visite accompagnée du marché pour 10 familles.

Corrigé

Quoi : visite accompagnée du marché, repérage des produits de saison et des prix. **Qui** : 10 familles inscrites ; diététicienne et référente ; placier du marché informé. **Où** : marché du centre-ville (2,5 km), trajet en bus. **Quand** : samedi 25 mars, 9 h 30 – 11 h 30. **Comment** : jeu de piste « 5 légumes de saison à moins de 2 €/kg », relevé de prix, achat collectif avec 15 € pour l'atelier suivant, retour avec recettes. **Combien** : 2 animatrices × 4 h ; tickets de bus 10 × 2 × 1,60 € = 32 € ; 15 € de denrées. **Pourquoi** : objectif spécifique 3 (connaître et utiliser l'offre à petit prix).

À vous de jouer – Exercice 9 – Matrice RACI

Construisez la matrice RACI de la préparation d'un atelier (achats, fiche technique, communication, accueil, évaluation) pour : diététicienne, animatrice, étudiante, directrice.

Corrigé

Achats : étudiante R, animatrice C, directrice A, diététicienne I. Fiche technique : étudiante R, diététicienne A (validation technique), animatrice C. Communication : animatrice R, étudiante C, directrice A. Accueil : animatrice R, étudiante R, directrice A (une seule personne A). Évaluation : étudiante R, diététicienne C, directrice A, animatrice I.

À vous de jouer – Exercice 10 – Tableau de bord

À mi-parcours d'un projet de 10 ateliers pour 15 personnes : 5 ateliers réalisés, 58 présences, 2 300 € dépensés sur 5 200 €. Calculez les indicateurs et commentez.

Corrigé

Ateliers : 5 / 10 = **50 %** (conforme au temps écoulé). Présences : 58 / (5 × 15) = 58 / 75 × 100 = **77,3 %** (légèrement sous l'objectif usuel de 80 % : relancer, analyser les absences). Budget : 2 300 / 5 200 × 100 = **44,2** % (légère sous-consommation, à surveiller : dépenses à venir ? économies ?).

8.8.3 Questions de réflexion

À vous de jouer – Question 1

Pourquoi les financeurs exigent-ils un cofinancement ?

Corrigé

Pour partager le risque, vérifier l'ancrage local du projet (d'autres acteurs y croient), éviter la dépendance à un seul financeur, favoriser la pérennisation et multiplier les projets financés avec une enveloppe limitée.

À vous de jouer – Question 2

Un projet très bien planifié peut-il échouer ?

Corrigé

Oui, si le diagnostic était erroné, si le public n'a pas été associé, si les partenaires ne s'engagent pas, si un risque n'a pas été anticipé ou si le plan est appliqué sans écoute des participants. Le pilotage (suivi, ajustements) et la participation sont aussi importants que la planification.

À vous de jouer – Question 3

Faut-il valoriser le bénévolat dans le budget ?

Corrigé

Oui : il montre la contribution réelle des acteurs (habitants, bénévoles), donne une image juste du coût du projet et renforce le dossier (ancrage local) ; il s'inscrit aux comptes 86 et 87, pour le même montant, sans effet sur la trésorerie.

8.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – Le projet « Petit-déjeuner pour tous » d'un collège en REP

Un collège de réseau d'éducation prioritaire (480 élèves) veut proposer un petit-déjeuner éducatif deux matins par semaine pendant 24 semaines pour les élèves de 6e (120 élèves, participation estimée à 60 %), avec 6 ateliers parents. Ressources : agents de restauration (3 h par matin à 20 €/h), infirmière (temps institutionnel non valorisé), diététicienne (6 ateliers × 2 h + 10 h de préparation à 40 €/h). Coût des denrées : 0,80 € par petit- déjeuner. Supports : 300 €.

1. Identifiez les parties prenantes et placez-les sur la matrice pouvoir/intérêt.
2. Calculez le nombre de petits-déjeuners servis et le budget prévisionnel des charges.
3. Proposez un plan de financement équilibré (au moins 3 financeurs) et calculez la part de chacun.
4. Construisez le Gantt simplifié (préparation, lancement, ateliers parents, évaluation).
5. Identifiez trois risques, évaluez leur criticité et proposez des mesures.

Corrigé

1. Gérer étroitement : principal, infirmière, gestionnaire, ARS ou collectivité financeuse. Satisfaire : département (propriétaire du collège, restauration), rectorat. Associer : élèves (délégués), parents, agents de restauration. Surveiller : fournisseurs.
2. Élèves participants : 120 × 0,60 = **72** ; matins : 2 × 24 = **48** ; petits-déjeuners : 72 × 48 = **3 456**. Denrées : 3 456 × 0,80 = **2 764,80 €**. Agents : 48 × 3 × 20 = **2 880 €**. Diététicienne : (6 × 2 + 10) × 40 = 22 × 40 = **880 €**. Supports : **300 €**. Total charges : 2 764,80 + 2 880 + 880 + 300 = **6 824,80 €**.
3. Exemple : département 2 880 € (temps des agents : 42,2 %) ; ARS (FIR) 2 500 € (36,6 %) ; programme national de petits-déjeuners à l'école, ou commune, 1 144,80 € (16,8 %) ; collège (fonds propres) 300 € (4,4 %) ; total 6 824,80 € . Calculs : 2 880 / 6 824,80 = 42,2 % ; 2 500 / 6 824,80 = 36,6 % ; 1 144,80 / 6 824,80 = 16,8 % ; 300 / 6 824,80 = 4,4 %.
4. Mai-juin : diagnostic et conventions ; septembre : achats, information des familles, formation des agents ; octobre à avril : petits-déjeuners (24 semaines hors vacances) ; ateliers parents en novembre, janvier, février, mars, avril, mai ; mai-juin : évaluation et bilan au COPIL.

5. Faible participation des élèves (P 3, G 3 = 9 : horaires de bus, communication par les délégués) ; allergies (P 2, G 4 = 8 : PAI, liste des allergènes) ; absence d'agents (P 2, G 3 = 6 : planning de remplacement).

8.8.5 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Comment avez-vous choisi vos partenaires ? »

Corrigé

À partir du diagnostic (ressources du territoire) et de la matrice pouvoir/intérêt ; j'ai retenu ceux dont la mission rejoignait nos objectifs (l'épicerie pour l'accès aux légumes secs) et formalisé leur engagement dans une convention.

Mise en situation – MSE 2

La date limite de l'appel à projets est dans 5 jours et le budget n'est pas équilibré.

Corrigé

J'identifie l'écart, j'ajuste le montant sollicité ou l'autofinancement avec la direction, je vérifie que chaque ligne est justifiée, je fais relire et je dépose au moins un jour avant la date limite.

Mise en situation – MSE 3

Le jury : « Qu'est-ce que le chemin critique ? »

Corrigé

C'est la suite des tâches sans marge qui détermine la durée minimale du projet ; tout retard sur l'une d'elles retarde l'ensemble. Dans mon projet, c'était le dépôt du dossier, la préparation des ateliers et le cycle d'ateliers.

Mise en situation – MSE 4

Un partenaire ne vient plus aux réunions.

Corrigé

Je le contacte pour comprendre (disponibilité, intérêt), je lui propose une forme de participation plus légère (point téléphonique, compte rendu), je lui montre ce que le projet lui apporte ; si besoin, j'ajuste la convention.

Mise en situation – MSE 5

Le jury : « Pourquoi avez-vous valorisé le bénévolat ? »

Corrigé

Pour montrer la contribution réelle des mamans relais et le coût complet du projet ; elle figure aux comptes 86 et 87 pour le même montant, sans effet sur la trésorerie.

Mise en situation – MSE 6

Le financeur vous demande pourquoi vous avez dépensé 12 % de plus en denrées.

Corrigé

J'explique la cause (hausse des prix des fruits), je montre la compensation par d'autres postes et l'écart global de 2,3 %, avec le tableau prévu/réalisé.

Mise en situation – MSE 7

Le jury : « Quelle différence entre le COPIL et le comité technique ? »

Corrigé

Le COPIL décide (orientations, validation, budget) et se réunit peu ; le comité technique organise et met en œuvre, avec des réunions fréquentes.

Mise en situation – MSE 8

Une animatrice tombe malade la veille d'un atelier.

Corrigé

J'applique le plan prévu : binôme de remplacement qui dispose du conducteur et de la fiche technique ; sinon, je réduis l'atelier à un format réalisable en sécurité ou je reporte en prévenant les familles.

Mise en situation – MSE 9

Le jury : « Qui a financé votre projet ? »

Corrigé

L'ARS (FIR) pour 42,7 %, la commune, la CAF, la participation des familles, l'autofinancement du centre social et des contributions en nature ; 71,2 % de financements publics.

Mise en situation – MSE 10

Le jury : « Votre projet est-il pérenne ? »

Corrigé

Des relais ont été formés (référente, mamans relais), les conducteurs et le livret sont réutilisables, l'action est inscrite au projet du centre social et une nouvelle demande est prévue dans le cadre du CLS.

Mise en situation – MSE 11

Une entreprise propose de financer tout le projet.

Corrigé

J'analyse le conflit d'intérêts (chapitre 6) et je préfère un cofinancement diversifié ; si le mécénat est accepté, c'est sans contrepartie sur le contenu, avec une convention et une mention transparente.

Mise en situation – MSE 12

Le jury : « Comment avez-vous suivi votre projet ? »

Corrigé

Avec un tableau de bord hebdomadaire (ateliers réalisés, présences, budget consommé, supports), une matrice des risques et trois réunions du COPIL avec comptes rendus et relevés d'actions.

8.8.6 Exercices complémentaires

À vous de jouer – Exercice 11 – Schéma à légender : le plan de communication

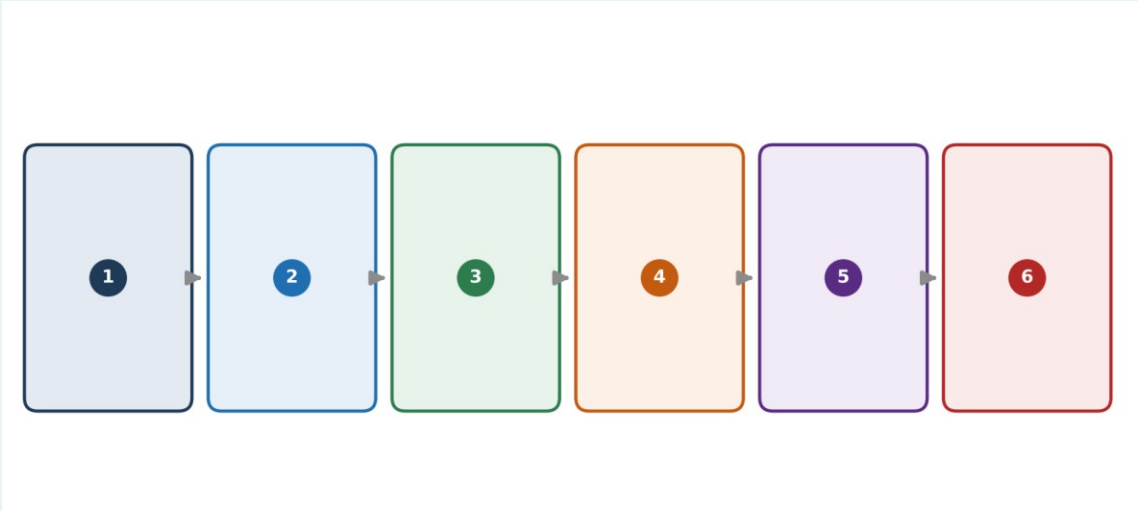


Figure 8.10 – Schéma à légender

Nommez les étapes 1 à 6, puis complétez-les pour un atelier « goûters » destiné aux parents d'une école.

Corrigé

1. Objectifs : 15 inscriptions. 2. **Cibles** : parents de l'école, enseignants (relais). 3. **Messages** : « Des goûters maison, bons et pas chers : venez les préparer avec nous ». 4. **Canaux** : cahier de liaison, affichage à l'entrée, mot des enseignants, parents relais. 5. **Calendrier** : 3 semaines avant, rappel la veille. 6. **Budget et évaluation** : impression 20 € ; inscriptions par canal.

À vous de jouer – Exercice 12 – Efficacité des canaux

Origine de 40 inscriptions : réseaux sociaux de la mairie 6 ; affiche en pharmacie 3 ; médecins et infirmières 9 ; associations de quartier 15 ; bouche-à-oreille 7. Calculez les parts et le coût par inscription de la campagne

d'affichage (12 affiches, 54 € d'impression) et des réseaux sociaux (publication sponsorisée : 60 €).

Corrigé

Vérification : 6 + 3 + 9 + 15 + 7 = **40**. Parts : réseaux **15 %** ; affiches **7,5 %** ; soignants **22,5 %** ; associations **37,5 %** ; bouche-à-oreille **17,5 %**. Coût par inscription : affiches 54 / 3 = **18 €** ; réseaux 60 / 6 = **10 €**. Les relais humains (associations, soignants, bouche-à-oreille) apportent 31 / 40 = **77,5 %** des inscriptions.

À vous de jouer – Exercice 13 – Quantités brutes

Pour 30 portions d'une soupe (recette pour 6 : 600 g de potiron épluché, 200 g de pommes de terre épluchées, 100 g d'oignon épluché), calculez les quantités brutes (rendements : potiron 70 %, pommes de terre 80 %, oignon 90 %) et le coût (potiron 1,80 €/kg ; pommes de terre 1,30 €/kg ; oignons 1,60 €/kg).

Corrigé

Coefficient : 30 / 6 = **5**. Potiron : 600 × 5 / 0,70 = 3 000 / 0,70 = **4 286 g** ; pommes de terre : 200 × 5 / 0,80 = 1 000 / 0,80 = **1 250 g** ; oignon : 100 × 5 / 0,90 = 500 / 0,90 = **556 g**. Coût : 4,286 × 1,80 = **7,71 €** ; 1,25 × 1,30 = **1,63** € ; 0,556 × 1,60 = **0,89 €** ; total **10,23 €**, soit 10,23 / 30 = **0,34 €** la portion (hors bouillon et épices).

À vous de jouer – Exercice 14 – Plan de trésorerie

Un projet : trésorerie de départ 300 € ; dépenses : sept. 400, oct. 600, nov. 600, déc. 300 ; recettes : oct. 500 (commune), janv. 1 500 (fondation). Calculez les soldes de fin de mois de septembre à janvier et le besoin maximal.

Corrigé

Sept. : 300 − 400 = **− 100** ; oct. : − 100 + 500 − 600 = **− 200** ; nov. : − 200 − 600 = **− 800** ; déc. : − 800 − 300 = **− 1 100** ; janv. : − 1 100 + 1 500 = **400**. Besoin maximal : **1 100 €** fin décembre ; solutions : acompte de la fondation, décalage des achats, trésorerie de la structure.

À vous de jouer – Exercice 15 – Choisir des méthodes

Pour chaque objectif, proposez une méthode et un outil : a) citer 3 sources de protéines végétales ; b) savoir cuire des pois chiches secs ; c) oser goûter un légume inconnu ; d) analyser une publicité pour des céréales.

Corrigé

a) Méthode interrogative : jeu de cartes-aliments à classer. b) Démonstrative puis active : trempage et cuisson en atelier, fiche en photos. c) Active, sans pression : dégustation à l'aveugle, vocabulaire sensoriel, modèle de l'animateur qui goûte. d) Active et coopérative : analyse en groupes avec une grille (biais, cibles, allégations), restitution.

À vous de jouer – Exercice 16 – Analyser un dossier de financement

Un dossier contient : « Les enfants mangent mal. Nous voulons sensibiliser les familles. Budget : 5 000 € demandés à l'ARS. » Listez 6 faiblesses et proposez une réécriture du premier paragraphe.

Corrigé

Faiblesses : constat sans donnée ni source ; jugement stigmatisant ; objectif non SMART (« sensibiliser ») ; pas d'actions décrites ; pas d'évaluation ; budget non détaillé et financé à 100 % par un seul financeur ; pas de partenaires ni de pérennisation. Réécriture : « Dans les deux écoles du quartier X (420 élèves), 13 % des enfants de grande section sont en surpoids contre 8 % dans le département (santé scolaire, 2026) ; 46 % des parents interrogés (n = 62) déclarent que leurs enfants boivent une boisson sucrée chaque jour. »

8.9 Glossaire

Terme	Définition
Appel à projets	Procédure par laquelle un financeur sélectionne des projets selon un cahier des charges
Autofinancement	Part du budget financée par les fonds propres du porteur
Cahier des charges	Document fixant priorités, publics, critères, montants et calendrier d'un appel à projets
Chemin critique	Suite des tâches sans marge déterminant la durée minimale du projet
Cofinancement	Financement d'un projet par plusieurs financeurs
Comité de pilotage (COPIL)	Instance de décision d'un projet
Contributions volontaires en nature	Bénévolat, prêts de locaux, dons valorisés (comptes 86 et 87)
Convention de partenariat	Document écrit fixant les engagements des partenaires
Criticité	Produit de la probabilité et de la gravité d'un risque
Diagramme de Gantt	Représentation des tâches sur une échelle de temps
FIR	Fonds d'intervention régional géré par l'ARS (art. L. 1435-8 CSP)
Jalon	Date clé d'un projet (dépôt, lancement, comité)
Marge	Retard possible d'une tâche sans retarder le projet
Matrice pouvoir/intérêt	Outil de classement des parties prenantes
Partie prenante	Acteur concerné par le projet ou pouvant l'influencer
PERT	Réseau des tâches et de leurs antériorités
Pilotage	Suivi, anticipation, décision et compte rendu tout au long du projet
QQOQCCP	Quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi
RACI	Réalise, approuve, consulté, informé
Tableau de bord	Ensemble d'indicateurs de suivi mis à jour régulièrement
Acompte	Versement partiel d'une subvention avant la fin de l'action
Coût par contact	Coût d'un support de communication rapporté au nombre de contacts obtenus
Méthode démonstrative	Méthode pédagogique où l'on montre un geste avant de le faire reproduire
Plan de communication	Organisation des objectifs, cibles, messages, canaux, calendrier et budget de la communication
Plan de trésorerie	Prévision mois par mois des encaissements, décaissements et du solde
Rendement (culinaire)	Part comestible d'un produit après épluchage, parage ou cuisson
SROI	Retour social sur investissement : valeur sociale créée rapportée à l'investissement

8.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Stratégies, données probantes	[1] Charte d'Ottawa ; [2] Santé publique France, interventions probantes
Partenariat, parties prenantes	[3] Mendelow ; [4] Callon
Financements	[5] CSP L. 1435-8 ; [6] loi du 28 décembre 2015 ; [7] Cerfa 12156 ; [8] Le Compte Asso
Planification	[9] Gantt ; [10] PERT (US Navy)
Budget	[11] Plan comptable associatif (règlement ANC 2018-06)
Démarche qualité	[12] INPES guide d'autoévaluation ; [13] Deming

8.12 Bibliographie numérotée

1. OMS. *Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé*. 1986.
2. Santé publique France. *Répertoire des interventions efficaces ou prometteuses en prévention et promotion de la santé*, *santepubliquefrance.fr*.
3. Mendelow A. « Stakeholder mapping ». *Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems*, Cambridge (MA), 1991.
4. Callon M. « Éléments pour une sociologie de la traduction ». *L'Année sociologique*, 1986, 36, p. 169-208.
5. Code de la santé publique, article L. 1435-8 (fonds d'intervention régional).
6. Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.
7. Formulaire Cerfa n° 12156 « Demande de subvention(s) » des associations, *service-public.fr*.
8. Le Compte Asso, *lecompteasso.associations.gouv.fr*.
9. Gantt H. L. *Work, Wages and Profits*. New York, 1910.
10. Malcolm D. G. et coll. « Application of a technique for research and development program evaluation » (PERT). *Operations Research*, 1959, 7 (5), p. 646-669.
11. Autorité des normes comptables. Règlement n° 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
12. INPES. *Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion de la santé ?* 2009.
13. Deming W. E. *Out of the Crisis*. MIT Press, 1986.
14. Santé publique France. *Communiquer pour tous : guide pour une information accessible*. 2018.
15. Masters K. « Edgar Dale's Pyramid of Learning in medical education: a literature review ». *Medical Teacher*, 2013, 35 (11), e1584-e1593.
16. Social Value International. *A Guide to Social Return on Investment*. 2012.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 8.2.2)

17. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE

CHAPITRE

08

Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage

Démarche de projet (2) | Stratégies | Partenaires | Financements | Calendrier

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

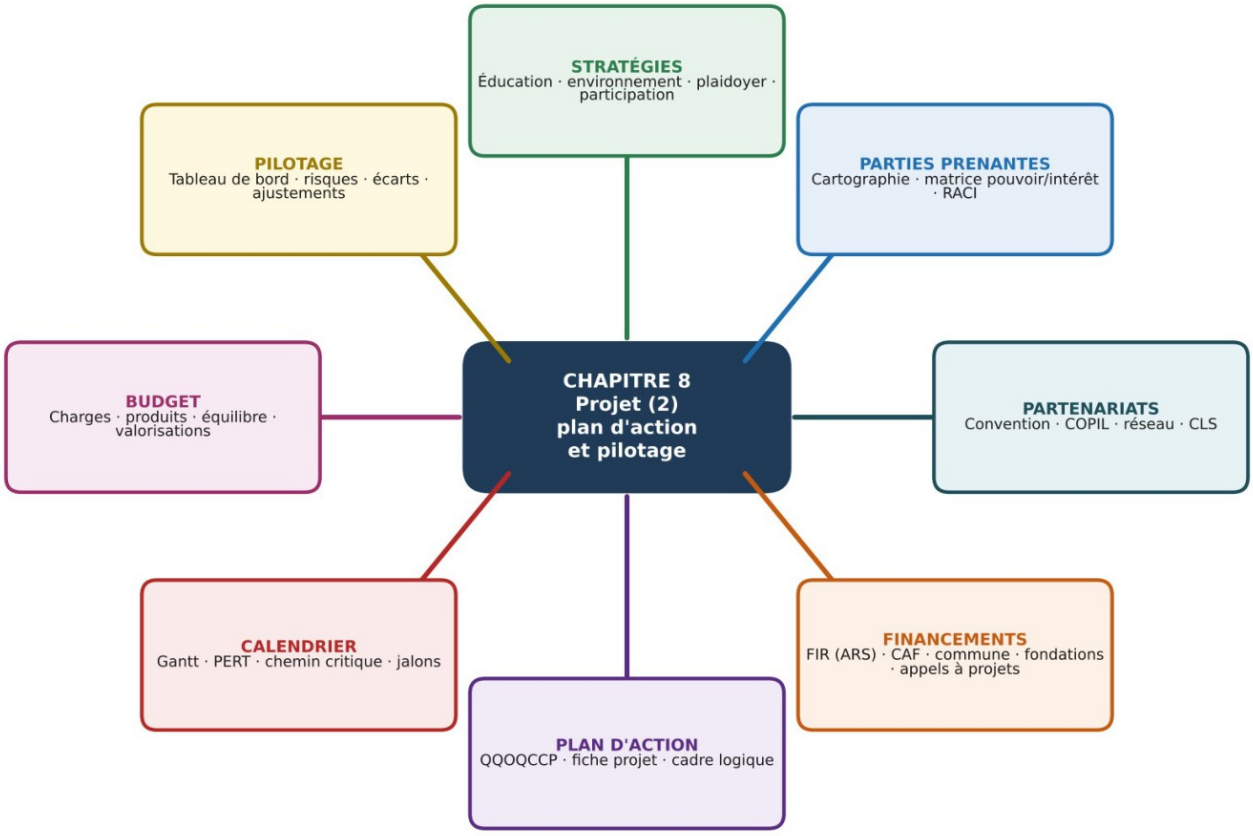
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 8 100
1. Les définitions à savoir 100
2. Les outils 100
3. Les formules 101
4. Les financeurs 101
5. Les pièges 101
6. Auto-test 101
7. Flashcards 101
Compléments du chapitre enrichi 102

Fiches-outils du chapitre 8 102
O8.1 – Fiche action QQOQCCP 102
O8.2 – Cartographie des parties prenantes 103
O8.3 – Matrice RACI 103
O8.4 – Analyse d'un cahier des charges 103
O8.5 – Calcul PERT 103
O8.6 – Suivi budgétaire prévu / réalisé 103
O8.7 – Registre des risques 103
O8.8 – Compte rendu de réunion 103

Fiche de révision du chapitre 8

Démarche de projet (2) : plan d'action, partenaires, financements, pilotage



Carte mentale du chapitre 8

1. Les définitions à savoir

Notion	Définition
Partie prenante / partenaire	Acteur concerné ou influent / acteur qui s'engage avec des ressources
COPIL / comité technique	Décide / organise et met en œuvre
Appel à projets	Sélection de projets selon un cahier des charges
Chemin critique	Tâches à marge nulle ; fixe la durée minimale
Marge	Date au plus tard − date au plus tôt
Criticité	Probabilité × gravité
Contributions en nature	Comptes 86 (charges) = 87 (produits)

2. Les outils

- **QQOQCCP** : quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi.
- **Matrice pouvoir/intérêt** : gérer étroitement · satisfaire · associer · surveiller.
- **RACI** : réalise · approuve (un seul) · consulté · informé.

- **Gantt** (tâches × temps, jalons) et **PERT** (antériorités, chemin critique).
- **Budget** : charges 60, 61-62, 64, 86 / produits 70, 74, 75, 87 ; équilibre ; cofinancement.
- **Tableau de bord** : ateliers, présences, budget consommé, délais.
- **Matrice des risques** : P × G de 1 à 16.

3. Les formules

Calcul	Formule et exemple
Ligne de budget	quantité × coût unitaire : 40 h × 38 € = 1 520 €
Coût horaire	coût employeur / 151,67 h : 2 840 / 151,67 = 18,73 €
Autofinancement	charges − autres produits : 3 510 − 3 094 = 416 €
Part d'un financeur	montant / total × 100 : 1 500 / 3 510 = 42,7 %
Écart budgétaire	(réalisé − prévu) / prévu × 100 : 26,40 / 210 = + 12,6 %
Date au plus tôt	max des fins des antériorités
Taux de présence	présences / (séances × inscrits) : 31 / 36 = 86,1 %

4. Les financeurs

ARS (FIR, art. L. 1435-8 CSP) · collectivités (CLS, contrat de ville, PAT) · CAF · conférence des financeurs (60 ans et plus, loi du 28/12/2015) · assurance maladie, mutuelles, caisses de retraite · fondations (vigilance conflits d'intérêts).

5. Les pièges

Attention

- Budget non équilibré ou 86 ≠ 87.
- Un seul financeur à 100 %.
- Plusieurs personnes « A » dans la RACI.
- Oublier les contraintes du calendrier (vacances, Ramadan, stage).
- Ne pas expliquer les écarts budgétaires.
- Déposer le dossier le dernier jour.

6. Auto-test

1. Que signifie QQOQCCP ? 2. Article du FIR ? 3. Public de la conférence des financeurs ? 4. Formule de la criticité ? 5. Comment calcule-t-on une date au plus tôt ? 6. Compte des subventions ? 7. Compte du personnel ? 8. Coût horaire de 2 660 € par mois ? 9. Rôle du COPIL ? 10. Que contient un compte rendu ?

Réponses : 1. Quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi – 2. L. 1435-8 CSP – 3. 60 ans et plus – 4. Probabilité × gravité – 5. Maximum des fins des tâches antérieures – 6. 74 – 7. 64 – 8. 2 660 / 151,67 = 17,54 € – 9. Décider – 10. Présents, décisions, relevé d'actions.

7. Flashcards

Recto : Cadre logique ?	Verso : Objectifs, indicateurs, sources de vérification, hypothèses
Recto : Cerfa des subventions ?	Verso : n° 12156 (ou plateforme Le Compte Asso)
Recto : CPOM ?	Verso : Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
Recto : PDCA ?	Verso : Planifier, faire, vérifier, agir (Deming)

Recto : Cadre logique ?	Verso : Objectifs, indicateurs, sources de vérification, hypothèses
Recto : Coût par résultat ?	Verso : 3 510 / 9 familles = 390 € (efficience)
Recto : Pérennisation ?	Verso : Relais formés, outils réutilisables, financements pluriannuels

Compléments du chapitre enrichi

Notion	À retenir
Plan de communication	Objectifs, cibles, messages, canaux, calendrier, budget, évaluation ; relais humains ; coût par contact
Méthodes	Expositive, interrogative, démonstrative, active, coopérative ; selon le type d'objectif ; « pyramide de l'apprentissage » = mythe
Logistique	Brut = net × coefficient / rendement (carottes 85 %, pommes de terre 80 %) ; check-list avant / J / après
Trésorerie	Solde = précédent + encaissements − décaissements ; besoin maximal ; acompte
Dossier de financement	Constats chiffrés, politiques, objectifs SMART, actions, participation, évaluation, budget cofinancé, pérennisation
Bénévoles	Mission, formation, reconnaissance ; comptes 86/87

Fiches-outils du chapitre 8

Outil	Intitulé	Utilité
O8.1	Fiche action QQOQCCP	Décrire chaque action du plan
O8.2	Cartographie des parties prenantes	Matrice pouvoir/intérêt et stratégie
O8.3	Matrice RACI	Répartir les rôles
O8.4	Analyse d'un cahier des charges	Vérifier l'éligibilité avant de répondre
O8.5	Calcul PERT	Dates, marges, chemin critique
O8.6	Suivi budgétaire prévu / réalisé	Analyser les écarts
O8.7	Registre des risques	Anticiper et réduire les risques
O8.8	Compte rendu de réunion	Décisions et relevé d'actions

O8.1 – Fiche action QQOQCCP

Question	Réponse
Quoi ?	
Qui ? (public, animateurs,	
partenaires)	
Où ?	
Quand ?	
Comment ? (méthodes,	
outils)	
Combien ? (moyens, coût)	

Question	Réponse
Pourquoi ? (objectif visé)	

O8.2 – Cartographie des parties prenantes

O8.3 – Matrice RACI

Inscrire les acteurs en en-tête ; R = réalise, A = approuve (un seul par tâche), C = consulté, I = informé.

O8.4 – Analyse d'un cahier des charges

Critère	Exigence de l'appel à projets	Mon projet conforme ?
Financeur, intitulé, date limite		
Publics et territoires prioritaires		
Actions éligibles / exclues		
Montant maximal, taux maximal		
Cofinancement exigé		
Durée, calendrier		
Évaluation demandée		
Pièces à joindre		
Critères de sélection		

O8.5 – Calcul PERT

Début au plus tôt = max des fins des antériorités ; fin au plus tard = min des débuts au plus tard des tâches suivantes ; marge = fin tard − fin tôt ; chemin critique = marges nulles.

O8.6 – Suivi budgétaire prévu / réalisé

Poste	Prévu (€)	Réalisé (€)	Écart (€ et %)	Explication
Total				

O8.7 – Registre des risques

O8.8 – Compte rendu de réunion

Réunion : ..... Date : ..... Lieu : ..... Présents : .....
Excusés : .....

1.

2.

3.

Prochaine réunion : .....

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES

CHAPITRE

08

Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage

Démarche de projet (2) | Stratégies | Partenaires | Financements | Calendrier

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 8 107
Mode d'emploi du cahier 107
Partie 1 – Les stratégies, les actions et la fiche action 109
Exercice 8.1 – Les stratégies d'intervention (10 points) 110
Exercice 8.2 – Rédiger une fiche action QQOQCCP (10 points) 112
Exercice 8.3 – Choisir une action avec des critères (12 points) 114
Exercice 8.4 – Relier les actions aux objectifs (12 points) 116
Exercice 8.5 – Adapter une action à un public (12 points) 118
Exercice 8.6 – Rédiger la partie « plan d'action » d'un dossier (16 points) 120
Corrigés de la partie 1 122
Partie 2 – Les parties prenantes, le partenariat et le pilotage 125
Exercice 8.7 – La matrice pouvoir/intérêt (10 points) 126
Exercice 8.8 – Organiser le pilotage du projet (10 points) 128
Exercice 8.9 – Corriger une matrice RACI (12 points) 130
Exercice 8.10 – Corriger une convention de partenariat (12 points) 132
Exercice 8.11 – Convaincre un partenaire réticent (12 points) 133
Exercice 8.12 – Rédiger le compte rendu d'une réunion de pilotage (16 points) 134
Corrigés de la partie 2 136
Partie 3 – Les financements et les appels à projets 139
Exercice 8.13 – Les étapes de la réponse à un appel à projets (10 points) 140
Exercice 8.14 – Qui finance quoi ? (10 points) 142
Exercice 8.15 – Lire un cahier des charges (12 points) 143
Exercice 8.16 – Construire un plan de financement (12 points) 145
Exercice 8.17 – Évaluer des dossiers avec une grille de sélection (12 points) 146
Exercice 8.18 – Relire un dossier de demande de subvention (16 points) 148
Corrigés de la partie 3 150
Partie 4 – Planifier le projet 153
Exercice 8.19 – Lire une tâche du réseau PERT (10 points) 154
Exercice 8.20 – Construire un diagramme de Gantt (10 points) 156
Exercice 8.21 – Calculer un réseau PERT complet (12 points) 157
Exercice 8.22 – Mesurer l'effet d'un retard (12 points) 159
Exercice 8.23 – Estimer la charge de travail et suivre une feuille de temps (12 points) 160
Exercice 8.24 – Fixer les dates réelles d'un cycle d'ateliers (16 points) 162
Corrigés de la partie 4 163
Partie 5 – Construire et suivre le budget 166
Exercice 8.25 – La structure d'un budget prévisionnel (10 points) 167
Exercice 8.26 – Calculer un coût horaire chargé (10 points) 169
Exercice 8.27 – Construire un budget équilibré (12 points) 170
Exercice 8.28 – Analyser un budget avec des ratios (12 points) 171
Exercice 8.29 – Analyser les écarts entre le prévu et le réalisé (12 points) 172
Exercice 8.30 – Calculer le coût complet d'un atelier et le seuil de participants (16 points) 174
Corrigés de la partie 5 175
Partie 6 – La trésorerie, la logistique et les méthodes pédagogiques 178
Exercice 8.31 – Le principe du plan de trésorerie (10 points) 179
Exercice 8.32 – Construire un plan de trésorerie sur huit mois (12 points) 181
Exercice 8.33 – Calculer les quantités à acheter (12 points) 182
Exercice 8.34 – Préparer la logistique d'un atelier (12 points) 183
Exercice 8.35 – Choisir une méthode pédagogique (10 points) 184

Exercice 8.36 – Coût et apports d'une recette d'atelier (16 points) 185
Corrigés de la partie 6 187

Partie 7 – Piloter : tableau de bord, risques et communication 190
Exercice 8.37 – La boucle du pilotage (10 points) 191
Exercice 8.38 – Construire une matrice des risques (12 points) 193
Exercice 8.39 – Analyser un tableau de bord multisite (12 points) 195
Exercice 8.40 – Construire un plan de communication (12 points) 196
Exercice 8.41 – Mesurer l'efficacité des canaux de communication (12 points) 198
Exercice 8.42 – Réagir à un imprévu en cours de projet (16 points) 199
Corrigés de la partie 7 201

Partie 8 – Synthèse : du plan d'action au cas complet 204
Exercice 8.43 – Compléter un cadre logique (10 points) 205
Exercice 8.44 – Préparer la pérennisation (12 points) 207
Exercice 8.45 – Organiser et valoriser le bénévolat (12 points) 209
Exercice 8.46 – Utiliser un tableur pour le budget et la trésorerie (12 points) 210
Exercice 8.47 – Défendre son plan d'action devant le jury (14 points) 211
Exercice 8.48 – Cas complet : le « bol du bénévole » d'un festival de musique (40 points) 212
Corrigés de la partie 8 216

Bilan : grille d'auto-évaluation 221

Cahier d'exercices – Chapitre 8

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 8 : choix des stratégies et des actions, fiche action (QQOQCCP), parties prenantes et partenariat, pilotage, financements et appels à projets, planification (Gantt, PERT), budget, trésorerie, logistique, méthodes pédagogiques, tableau de bord, risques, communication, pérennisation (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition » et C3.5 « Communiquer et interagir dans un contexte d'intervention en santé » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les stratégies d'intervention, le QQOQCCP, la matrice pouvoir/intérêt, l'organisation du pilotage, la réponse à un appel à projets, la tâche PERT, la structure d'un budget, le plan de trésorerie, la matrice des risques, le plan de communication, la boucle du pilotage.
- Calculer et interpréter : coût d'une action, coût horaire chargé, budget équilibré, ratios, écarts prévu/réalisé, subvention selon un plafond et un taux, dates au plus tôt et au plus tard, marges, solde de trésorerie, quantités brutes, taux de présence, criticité, coût par contact, apports d'une recette (Ciqual 2025).
- Rédiger les parties « plan d'action », « partenariat », « budget » et « pilotage » d'un dossier de projet, et les défendre à l'oral.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits de dossiers), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, communes, personnes, appels à projets, prix, salaires et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025). Les textes officiels, les auteurs et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Traiter une question de plan d'action à l'examen

Pour chaque question, suivez quatre temps. D'abord, relevez dans les documents les objectifs, le public, les ressources et les règles imposées (budget, financeur, calendrier). Ensuite, faites les calculs en posant la formule, l'application numérique et le résultat avec son unité (euros, heures, semaines, pourcentage). Puis vérifiez la cohérence : budget équilibré, comptes 86 et 87 égaux, dépendances du planning respectées, trésorerie jamais négative sans solution. Enfin, concluez par une décision argumentée. Une copie qui donne

> un chiffre sans le vérifier, ou une décision sans chiffre, perd des points.

Partie 1 – Les stratégies, les actions et la fiche action

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les six grandes stratégies d'intervention et classer une action dans la bonne stratégie.
- Décrire une action avec la méthode QQOQCCP et chiffrer ses moyens.
- Choisir une action avec des critères explicites (cohérence, efficacité, adaptation, faisabilité, acceptabilité, éthique).
- Relier chaque action à un objectif spécifique et repérer les actions « orphelines ».
- Adapter une action aux capacités et à la culture d'un public.
- Rédiger la partie « plan d'action » d'un dossier de projet.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Les objectifs spécifiques disent ce qui doit changer ; les stratégies disent par quels leviers ; les actions disent ce que l'on fait concrètement.
- Six stratégies : éducation pour la santé ; action sur l'environnement ; lien social et entourage ; participation et développement du pouvoir d'agir ; plaidoyer ; formation des relais. Les interventions efficaces en nutrition combinent plusieurs stratégies (Charte d'Ottawa, 1986).
- QQOQCCP : Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ? Une fiche action complète répond aux sept questions.
- Six questions pour choisir une action : cohérence avec un objectif, efficacité prouvée, adaptation au public, faisabilité, acceptabilité et participation, éthique.
- Une action sans objectif est une action « orpheline » : on la supprime ou on la rattache à un objectif. Un objectif sans action ne sera pas atteint.

Exercice 8.1 – Les stratégies d'intervention (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

La maison de quartier des Coteaux (structure fictive) a posé son diagnostic : les familles du quartier consomment peu de fruits et de légumes, le seul commerce alimentaire est une supérette chère, et les parents se sentent seuls face aux refus des enfants. L'équipe a listé huit idées d'actions. Votre tutrice vous demande de vérifier que le projet combine plusieurs stratégies.

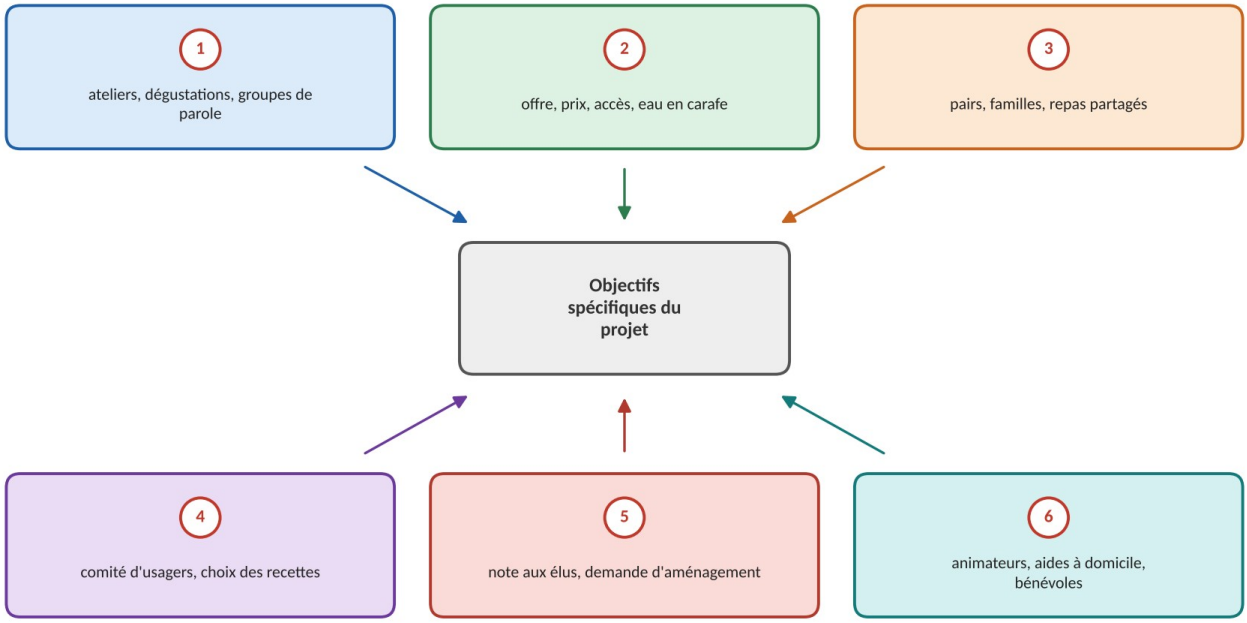


Figure 8.1 – Document 1 – Six stratégies au service des objectifs spécifiques (schéma à légender)

Document 2 – Huit idées d'actions

a) Trois ateliers « cuisiner les légumes de saison » avec dégustation.

b) Un marché de producteurs une fois par mois sur la place, avec des prix négociés.

c) Un groupe de parole de parents sur les refus alimentaires des enfants, animé avec la PMI.

d) Un comité de quatre parents qui choisit les recettes et les thèmes des ateliers.

e) Une note aux élus pour demander un arrêt de bus près du supermarché de la zone commerciale.

f) La formation des quatre animateurs du périscolaire à la découverte sensorielle.

g) Un « goûter des familles » mensuel où chaque famille apporte un plat.

h) Une exposition d'affiches sur les repères du PNNS dans le hall.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Classez les huit actions du document 2 dans ces six stratégies. (4 pts)
3. Dites quelle action risque d'être la moins efficace si elle est menée seule, et pourquoi. (1,5 pt)
4. Expliquez pourquoi il faut combiner plusieurs stratégies dans un projet de nutrition. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.2 – Rédiger une fiche action QQOQCCP (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le relais petite enfance (RPE) de Saint-Ombre (structure fictive) veut proposer aux assistantes maternelles un atelier « goûters faits maison pour les tout-petits ». L'animatrice du RPE vous transmet ses notes en vrac et vous demande une fiche action propre.

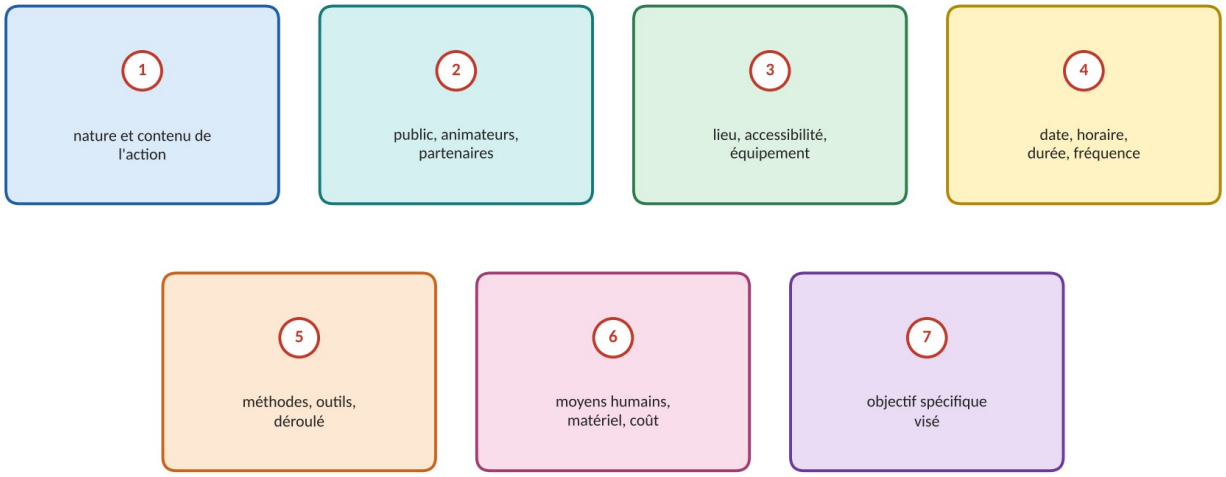


Figure 8.2 – Document 1 – Les sept questions de la méthode QQOQCCP (schéma à légender)

Document 2 – Notes de l'animatrice

« Ce serait un samedi matin, le 13 mars 2027, de 9 h 30 à 12 h, dans la salle d'activités du RPE (il y a un four et deux plaques). On prend 10 assistantes maternelles maximum, inscription au RPE. Je co-anime avec vous. Elles veulent des idées de goûters sans biscuits industriels, parce que 7 sur 12 interrogées en janvier disent acheter des biscuits par manque d'idées. On ferait trois recettes : compote pomme-banane, petits pancakes aux flocons d'avoine, yaourt nature et fruits. Puis on goûte et on échange sur les quantités adaptées à l'âge. Préparation : une heure à deux la veille ; rangement : 30 minutes à deux. Objectif spécifique 2 du projet : augmenter la part de goûters faits maison servis aux enfants accueillis. »

Document 3 – Liste des denrées (prix fictifs)

Denrée	Quantité	Prix
Farine de blé T65	400 g	1,10 € le kg
Œufs	6	0,30 € l'œuf
Yaourts nature	4 pots	0,25 € le pot
Pommes	1,5 kg	2,40 € le kg
Flocons d'avoine	300 g	2,60 € le kg
Lait demi-écrémé	1 L	1,05 € le litre
Bananes	1 kg	1,90 € le kg
Huile de colza	10 cl	2,80 € le litre

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)
2. Calculez le coût des denrées de l'atelier et le coût par participante. (2,5 pts)
3. Calculez le temps de travail des deux animatrices pour cet atelier. (1 pt)
4. Rédigez la fiche action sous la forme d'un tableau QQOQCCP. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.3 – Choisir une action avec des critères (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La résidence sociale Les Platanes (structure fictive) héberge 85 hommes âgés de 58 à 84 ans, pour la plupart arrivés d'Afrique du Nord pour travailler dans les années 1970. Ils disposent d'une cuisine commune par étage. Le diagnostic montre que beaucoup sont traités pour un diabète de type 2, mangent seuls, et lisent peu le français. L'équipe hésite entre quatre actions et a noté chacune de 0 (pas du tout) à 3 (tout à fait) sur les six critères de choix.

Document 1 – Notes de l'équipe (0 à 3)

Action	Cohérence	Efficacité	Adaptation	Faisabilité	Acceptabilité	Éthique
A – Conférence d'un médecin sur le diabète, dans la salle commune	1	1	0	3	1	2
B – Ateliers de cuisine collective : plats du pays adaptés, cuisinés et partagés	3	2	3	2	3	3
C – Distribution de dépliants nationaux sur le diabète, en français	1	0	0	3	1	2
D – Partenariat avec l'épicier voisin pour un panier hebdomadaire de légumes à prix réduit	3	2	2	1	2	2

À vous de jouer – Questions

1. Rappelez la question que pose chacun des six critères. (3 pts)

2. Calculez le score total de chaque action et classez-les. (2 pts)

3. Justifiez les notes « adaptation » des actions A et C. (2 pts)

4. Proposez une combinaison de deux actions et dites à quelles stratégies elles appartiennent. (2 pts)

5. Proposez une modification de l'action A qui améliore sa note d'adaptation et d'acceptabilité. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.4 – Relier les actions aux objectifs (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le club des retraités de la vallée du Lizon (association fictive, 140 adhérents en zone rurale) prépare un projet « Bien manger, bien vieillir ». Le bureau a écrit les objectifs et une liste d'actions, mais personne n'a vérifié qu'elles correspondent.

Document 1 – Objectifs spécifiques (à 12 mois)

OS1 – Augmenter de 35 % à 55 % la part des adhérents qui consomment un produit laitier à chaque repas.

OS2 – Augmenter de 20 % à 40 % la part des adhérents vivant seuls qui partagent au moins un repas par semaine.

OS3 – Faire passer de 3 à 8 le nombre de pesées mensuelles proposées par les relais du club, pour repérer les pertes de poids.

Document 2 – Actions proposées par le bureau

a) Un repas partagé mensuel au foyer rural, préparé par un groupe de volontaires.

b) Une formation de deux heures pour huit bénévoles relais : peser, noter, orienter vers le médecin traitant.

c) Une sortie annuelle au salon de l'agriculture.

d) Quatre ateliers « desserts lactés faciles et peu coûteux ».

e) Un concours de belote.

f) Un covoiturage solidaire vers le repas partagé.

g) L'achat d'un pèse-personne par relais.

h) Une conférence sur l'ostéoporose avec un rhumatologue.

À vous de jouer – Questions

1. Rattachez chaque action à un objectif spécifique quand c'est possible. (4 pts)
2. Repérez les actions « orphelines » et dites ce que vous en faites. (2 pts)
3. Classez les actions retenues selon les facteurs du modèle PRECEDE (prédisposants, facilitants, de renforcement). (3 pts)
4. Un objectif est-il mal couvert ? Proposez une action complémentaire. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.5 – Adapter une action à un public (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle courte · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association Mains et Voix (structure fictive) accompagne des adultes sourds qui communiquent en langue des signes française (LSF). Sa coordinatrice voudrait reprendre un atelier « lire les étiquettes au supermarché » conçu par une mutuelle pour le grand public. Vous devez l'adapter.

Document 1 – L'atelier tel qu'il est conçu pour le grand public

Séquence	Contenu	Durée
1	Exposé oral avec diaporama : la liste des ingrédients, le tableau nutritionnel, le Nutri-Score	30 min
2	Quiz à main levée : « Quel produit contient le plus de sucre ? »	15 min
3	Visite du supermarché en groupe de 15 : l'animatrice commente au micro portatif	45 min
4	Questionnaire de satisfaction écrit	10 min

Document 2 – Ce que dit la coordinatrice

« Nos adhérents lisent le français avec des niveaux très variables. Beaucoup ont eu une scolarité difficile. Une interprète LSF coûte 60 € de l'heure (tarif fictif) et il faut la réserver trois semaines avant. Dans un supermarché, on ne peut pas tous regarder l'animatrice en même temps : il faut se voir. Et nos adhérents détestent qu'on parle d'eux à la troisième personne devant eux. »

À vous de jouer – Questions

1. Repérez trois obstacles de l'atelier actuel pour ce public. (3 pts)
2. Proposez un nouveau déroulé en quatre séquences, avec les méthodes et les supports. (5 pts)
3. Calculez le coût de l'interprète pour un atelier de 2 h 30 avec 30 minutes de préparation commune. (1 pt)
4. Proposez une façon d'associer les adhérents à la conception de l'atelier. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.6 – Rédiger la partie « plan d'action » d'un dossier (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au centre communal d'action sociale (CCAS) de Mérovel (commune fictive de 9 000 habitants, ancienne cité minière). Le diagnostic a été validé. Vous devez rédiger la partie « plan d'action » du dossier de projet, en une page et demie.

Document 1 – Extrait du diagnostic validé (données fictives, 2026)

- 62 % des 48 bénéficiaires de l'épicerie sociale interrogés ne cuisinent jamais de légumes secs ; 71 % disent « ne pas savoir les préparer ».
- L'épicerie sociale reçoit des légumes secs de la banque alimentaire, mais 40 % sont jetés ou redonnés faute de demande.
- Les bénéficiaires demandent « des recettes rapides » et « pouvoir goûter avant d'acheter ».
- Ressources : cuisine pédagogique au centre social (12 places), une conseillère en économie sociale et familiale (CESF), deux bénévoles qui cuisinent volontiers, une diététicienne libérale qui accepte quatre interventions.

Document 2 – Objectifs validés par le comité de pilotage

Objectif général : contribuer à améliorer l'alimentation des bénéficiaires de l'épicerie sociale de Mérovel.

OS1 – Dans un an, 40 % des bénéficiaires interrogés cuisinent des légumes secs au moins une fois par semaine (valeur initiale : 0 % chaque semaine, 38 % au moins de temps en temps).

OS2 – Dans un an, réduire de 40 % à 15 % la part des légumes secs jetés ou redonnés par l'épicerie.

À vous de jouer – Questions

1. Proposez trois actions qui combinent au moins deux stratégies, et rattachez chacune à un objectif. (4 pts)
2. Rédigez la fiche QQOQCCP de l'action principale. (4 pts)
3. Calculez le nombre de places offertes si l'on organise quatre ateliers de 12 places, et la part des 48 bénéficiaires interrogés qu'il permet de toucher si chaque personne ne vient qu'une fois. Commentez. (2 pts)
4. Proposez deux objectifs opérationnels SMART. (3 pts)
5. Rédigez le paragraphe d'introduction du plan d'action (6 à 8 lignes). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 8.1

1. Légendes : 1 Éducation pour la santé ; 2 Action sur l'environnement ; 3 Lien social et entourage ; 4 Participation et pouvoir d'agir ; 5 Plaidoyer ; 6 Formation des relais.
2. Éducation pour la santé : a) ateliers de cuisine, h) exposition d'affiches. Action sur l'environnement : b) marché de producteurs à prix négociés. Lien social et entourage : c) groupe de parole de parents, g) goûter des familles. Participation : d) comité de parents. Plaidoyer : e) note aux élus pour un arrêt de bus. Formation des relais : f) formation des animateurs du périscolaire. Une action peut relever de deux stratégies : le groupe de parole (c) relève aussi de l'éducation pour la santé.
3. L'**exposition d'affiches** (h) : elle transmet une information, mais elle ne donne ni compétence, ni accès, ni soutien. Une information seule change peu les comportements, surtout chez les publics qui ont peu de moyens.
4. Les comportements alimentaires dépendent de facteurs individuels (savoir cuisiner), environnementaux (prix, offre, transport) et sociaux (soutien de l'entourage). Agir sur un seul facteur laisse les autres freins en place. La Charte d'Ottawa (1986) recommande d'agir à la fois sur les aptitudes individuelles, les milieux, l'action communautaire et les politiques.

Corrigé – Exercice 8.2

1. Légendes : 1 Quoi ? ; 2 Qui ? ; 3 Où ? ; 4 Quand ? ; 5 Comment ? ; 6 Combien ? ; 7 Pourquoi ?
2. Farine : 0,4 × 1,10 = 0,44 € ; œufs : 6 × 0,30 = 1,80 € ; yaourts : 4 × 0,25 = 1,00 € ; pommes : 1,5 × 2,40 = 3,60 € ; flocons : 0,3 × 2,60 = 0,78 € ; lait : 1,05 € ; bananes : 1,90 € ; huile : 0,1 × 2,80 = 0,28 €. **Total : 10,85 €**, soit 10,85 / 10 = **1,09 € par participante** (1,085 arrondi).
3. Par animatrice : 1 h de préparation + 2 h 30 d'atelier + 30 min de rangement = 4 h ; pour deux animatrices : **8 heures**.
4. Fiche action (exemple) :

Question	Réponse
Quoi ?	Atelier « goûters faits maison pour les tout-petits » : trois recettes (compote pomme-banane, pancakes aux flocons d'avoine, yaourt nature et fruits), dégustation, échange sur les quantités adaptées à l'âge
Qui ?	10 assistantes maternelles au plus, inscrites au RPE ; animatrice du RPE et stagiaire en diététique
Où ?	Salle d'activités du RPE (four, deux plaques)
Quand ?	Samedi 13 mars 2027, de 9 h 30 à 12 h
Comment ?	Démonstration courte puis réalisation en trois groupes, dégustation, échange ; fiches recettes illustrées remises à la fin
Combien ?	10,85 € de denrées (1,09 € par participante) ; 8 heures de travail pour deux animatrices ; matériel du RPE
Pourquoi ?	Objectif spécifique 2 : augmenter la part de goûters faits maison servis aux enfants accueillis (7 assistantes maternelles sur 12 achètent des biscuits par manque d'idées)

Corrigé – Exercice 8.3

1. Cohérence : l'action répond-elle à un objectif spécifique et à une cause du diagnostic ? Efficacité : existe-t-il des preuves ou des retours d'expérience ? Adaptation : convient-elle à la langue, à la culture, à la littératie, aux horaires et au budget du public ? Faisabilité : a-t-on les compétences, les locaux, le temps et l'argent ? Acceptabilité : le public la souhaite-t-il, a-t-il été consulté ? Éthique : est-elle non stigmatisante, équitable, indépendante ?
2. A : 1 + 1 + 0 + 3 + 1 + 2 = **8** ; B : 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 3 = **16** ; C : 1 + 0 + 0 + 3 + 1 + 2 = **7** ; D : 3 + 2 + 2 + 1 + 2 + 2

= **12**. Classement : **B (16), D (12), A (8), C (7)**.

3. A : une conférence en français, sans support visuel adapté, ne convient pas à des hommes qui lisent peu le français et qui ont l'habitude de cuisiner leurs plats ; elle ne tient pas compte de leurs habitudes. C : des dépliants nationaux en français sont illisibles pour une partie des résidents ; ils ne parlent ni de leurs plats, ni de leur cuisine commune.

4. Exemple : **B + D**. Les ateliers de cuisine relèvent de l'éducation pour la santé et du lien social (repas partagés) ; le panier de légumes à prix réduit relève de l'action sur l'environnement (accès, prix). Les ateliers donnent l'envie et le savoir-faire, le panier donne l'accès aux produits.

5. Exemple : remplacer la conférence par un **temps d'échange autour d'un thé**, animé par le médecin et un résident relais qui traduit en arabe ; partir des questions des résidents (« Puis-je manger du couscous ? ») ; utiliser des photos de leurs plats et des portions réelles ; inviter par le bouche-à-oreille du conseil de concertation des résidents.

Corrigé – Exercice 8.4

1. OS1 (produits laitiers) : d) ateliers desserts lactés ; h) conférence sur l'ostéoporose (lien indirect avec le calcium). OS2 (repas partagés) : a) repas partagé mensuel ; f) covoiturage vers le repas. OS3 (pesées) : b) formation des bénévoles relais ; g) achat de pèse-personnes.

2. Actions orphelines : c) sortie au salon de l'agriculture et e) concours de belote. Elles ne répondent à aucun objectif du projet. On les sort du projet (elles peuvent rester des activités du club, financées autrement), ou on les transforme : un concours de belote suivi d'un goûter lacté pourrait servir OS1 et OS2, à condition de le décrire comme tel.

3. Prédisposants (connaissances, motivations) : h) conférence, d) ateliers (découvrir des recettes). Facilitants (compétences, accès, ressources) : d) ateliers (savoir-faire), f) covoiturage, g) pèse-personnes, b) formation des relais. De renforcement (soutien, entourage) : a) repas partagé, b) relais qui encouragent et suivent.

4. L'OS2 vise les adhérents **vivant seuls**, mais rien ne garantit qu'ils viendront au repas mensuel ; un seul repas par mois ne suffit pas pour atteindre « un repas partagé par semaine ». Action complémentaire : des binômes « repas à deux » chaque semaine entre adhérents voisins, avec un relais qui les met en contact, ou un repas hebdomadaire tournant chez les adhérents volontaires.

Corrigé – Exercice 8.5

1. Exemples : l'exposé oral de 30 minutes repose sur l'écoute (inaccessible sans interprète) et sur la lecture d'un diaporama (difficile pour une partie du public) ; la visite commentée au micro, en groupe de 15, est impossible à suivre puisqu'il faut voir l'animatrice ou l'interprète ; le questionnaire écrit exclut ceux qui lisent mal ; le quiz à main levée suppose de suivre une question orale.

2. Exemple de déroulé :

Séquence	Contenu, méthode et supports	Durée
1	Accueil en LSF avec l'interprète ; jeu de tri d'emballages réels apportés par les adhérents (méthode active)	25 min
2	Démonstration visuelle : repérer le sucre et le sel sur trois emballages agrandis, pictogrammes, Nutri-Score en couleurs (méthode démonstrative)	25 min
3	Visite du supermarché en deux groupes de 5 à 6, en arc de cercle pour se voir ; chaque groupe compare deux produits et note sa réponse avec des pictogrammes (méthode active et coopérative)	1 h
4	Retour en salle : chaque groupe présente sa découverte en LSF ; évaluation avec des cartes de couleur (vert, orange, rouge)	40 min

3. Durée de présence de l'interprète : 2 h 30 + 30 min = 3 h ; coût : 3 × 60 = **180 €**.

4. Exemples : réunir trois adhérents volontaires avant l'atelier pour choisir les produits à comparer et tester les supports ; former un adhérent pair qui co-anime en LSF ; parler aux personnes directement (et non à l'interprète), comme le demande la coordinatrice.

Corrigé – Exercice 8.6

1. Exemples : A1 – quatre ateliers « légumes secs en 30 minutes » avec dégustation (éducation pour la santé) → OS1 ; A2 – dégustation mensuelle à l'épicerie sociale, avec fiche recette et sachet de légumes secs à emporter (action sur l'environnement et éducation) → OS1 et OS2 ; A3 – un comité de trois bénéficiaires et deux bénévoles qui choisit et teste les recettes (participation) → OS1 et OS2.

2. Fiche QQOQCCP de A1 (exemple) : Quoi ? quatre ateliers de cuisine « légumes secs en 30 minutes » ; Qui ? 12 bénéficiaires par atelier, la CESF, la diététicienne, deux bénévoles ; Où ? cuisine pédagogique du centre social ; Quand ? un mardi matin par mois, de 9 h 30 à 12 h, de février à mai 2027 ; Comment ? démonstration, réalisation en trois groupes, dégustation, recette illustrée, sachet de légumes secs offert par l'épicerie ; Combien ? 4 interventions de la diététicienne, temps de la CESF, denrées issues de l'épicerie ; Pourquoi ? OS1 et OS2.

3. Places : 4 × 12 = **48 places**. Si chaque personne vient une fois, on peut toucher au plus 48 personnes, soit 48 / 48 × 100 = **100 %** des bénéficiaires interrogés. Commentaire : c'est un maximum théorique ; en pratique, certaines personnes reviendront et d'autres ne viendront pas. Il faut compléter par une action qui touche tous les bénéficiaires sur place (dégustations à l'épicerie).

4. Exemples : « Organiser 4 ateliers de 12 places entre février et mai 2027 au centre social, avec un taux de remplissage d'au moins 75 %. » « Proposer une dégustation de légumes secs à l'épicerie sociale le premier jeudi de chaque mois, de mars à décembre 2027, soit 10 dégustations. »

5. Exemple : « Le plan d'action répond aux deux objectifs spécifiques validés par le comité de pilotage. Il combine l'éducation pour la santé (ateliers culinaires), l'action sur l'environnement (dégustations et sachets de légumes secs à l'épicerie sociale) et la participation (comité de recettes). Ce choix s'appuie sur le diagnostic : 71 % des bénéficiaires disent ne pas savoir préparer les légumes secs, alors que l'épicerie en dispose et en perd 40 %. Les actions mobilisent les ressources du territoire : la cuisine pédagogique, la CESF, deux bénévoles et une diététicienne. Elles sont décrites ci-dessous avec la méthode QQOQCCP. »

Partie 2 – Les parties prenantes, le partenariat et le pilotage

Objectifs – Objectifs de la partie

- Placer les parties prenantes dans la matrice pouvoir/intérêt et en déduire la façon de les associer.
- Organiser les instances du projet : comité de pilotage, comité technique, comité d'usagers.
- Construire et corriger une matrice RACI.
- Rédiger et corriger les articles d'une convention de partenariat.
- Convaincre un partenaire en montrant ce que le projet lui apporte.
- Rédiger le compte rendu d'une réunion de pilotage avec un relevé de décisions.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Partie prenante : personne ou organisation concernée par le projet ou capable de l'influencer. Partenaire : partie prenante qui s'engage et apporte des ressources selon des modalités définies.
- Matrice pouvoir/intérêt (d'après Mendelow, 1991) : pouvoir fort et intérêt fort, gérer étroitement ; pouvoir fort et intérêt faible, satisfaire ; pouvoir faible et intérêt fort, associer et informer ; pouvoir faible et intérêt faible, surveiller.
- Matrice RACI : R réalise ; A approuve et rend compte (une seule personne A par tâche) ; C consulté ; I informé. Chaque tâche a au moins un R et exactement un A.
- Comité de pilotage : il décide (2 à 3 réunions). Comité technique : il organise et suit le tableau de bord. Comité d'usagers : il donne l'avis des personnes concernées.
- Convention de partenariat : objet, engagements de chaque partie, durée, communication, données personnelles, suivi, modification et résiliation, signatures.
- Compte rendu : envoyé sous 48 heures ; présents et excusés, points abordés, décisions, relevé des actions (quoi, qui, pour quand).

Exercice 8.7 – La matrice pouvoir/intérêt (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution et application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

La commune du Val-d'Orbe (fictive) veut installer un réfrigérateur solidaire devant la salle des fêtes : les commerçants et les habitants y déposent des produits frais, et chacun peut se servir librement. Une association de bénévoles gérerait le nettoyage et le contrôle des dates. Vous préparez la cartographie des parties prenantes.

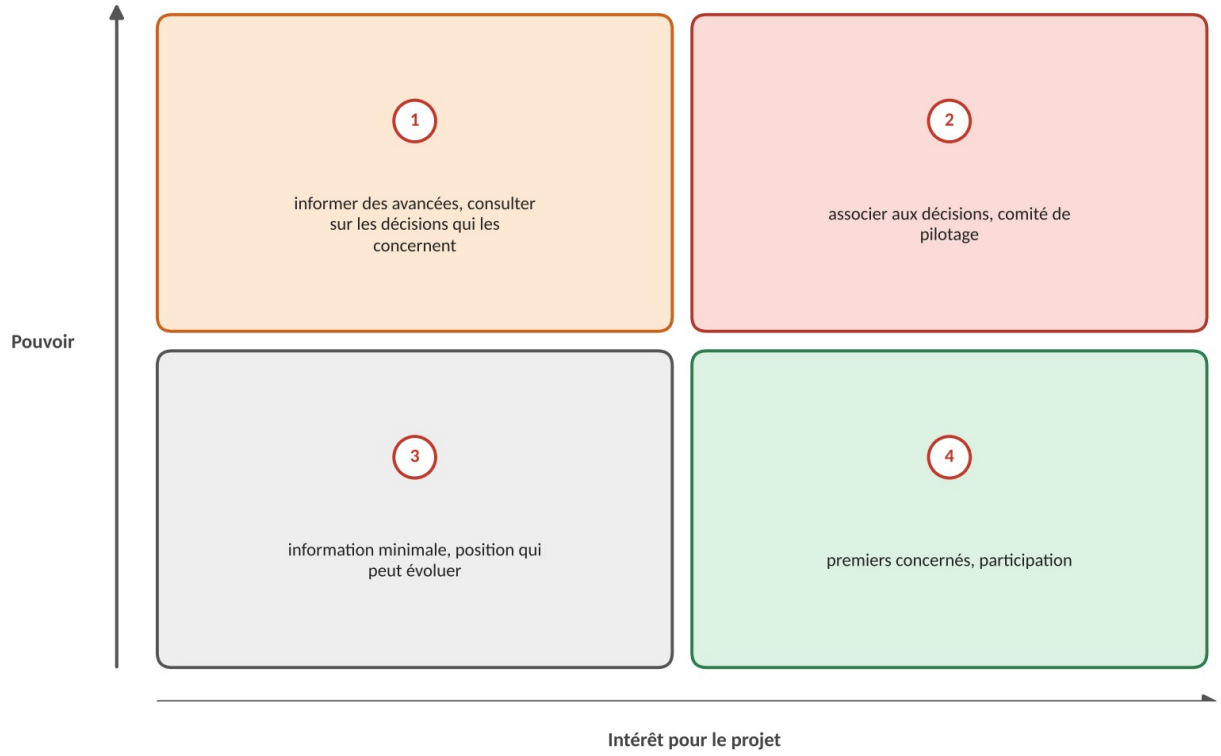


Figure 8.3 – Document 1 – La matrice pouvoir/intérêt (schéma à légender)

Document 2 – Dix parties prenantes

a) Le maire et le conseil municipal, qui financent l'achat du réfrigérateur.

b) La direction départementale de la protection des populations (DDPP), qui contrôle l'hygiène des denrées.

c) Les habitants qui utiliseront le réfrigérateur.

d) Les bénévoles de l'association qui le gérera.

e) Le supermarché qui donnera ses invendus.

f) Les riverains de la salle des fêtes.

g) La fondation qui pourrait financer l'entretien.

h) Le journal local.

i) La boulangerie, qui hésite à donner son pain de la veille.

j) La directrice du CCAS, qui oriente les personnes en difficulté et copilote le projet.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)

2. Placez les dix parties prenantes dans la matrice. (5 pts)

3. Dites comment associer concrètement les habitants (c) et les riverains (f). (2 pts)

4. Expliquez pourquoi la matrice doit être mise à jour en cours de projet, avec un exemple tiré du document 2. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.8 – Organiser le pilotage du projet (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le bailleur social Habitat du Causse (structure fictive) lance, avec le centre social et la diététicienne de la maison de santé, un projet « Cuisiner dans un petit logement » pour les locataires de la résidence des Genêts (180 logements). Il vous demande de proposer l'organisation des instances du projet.

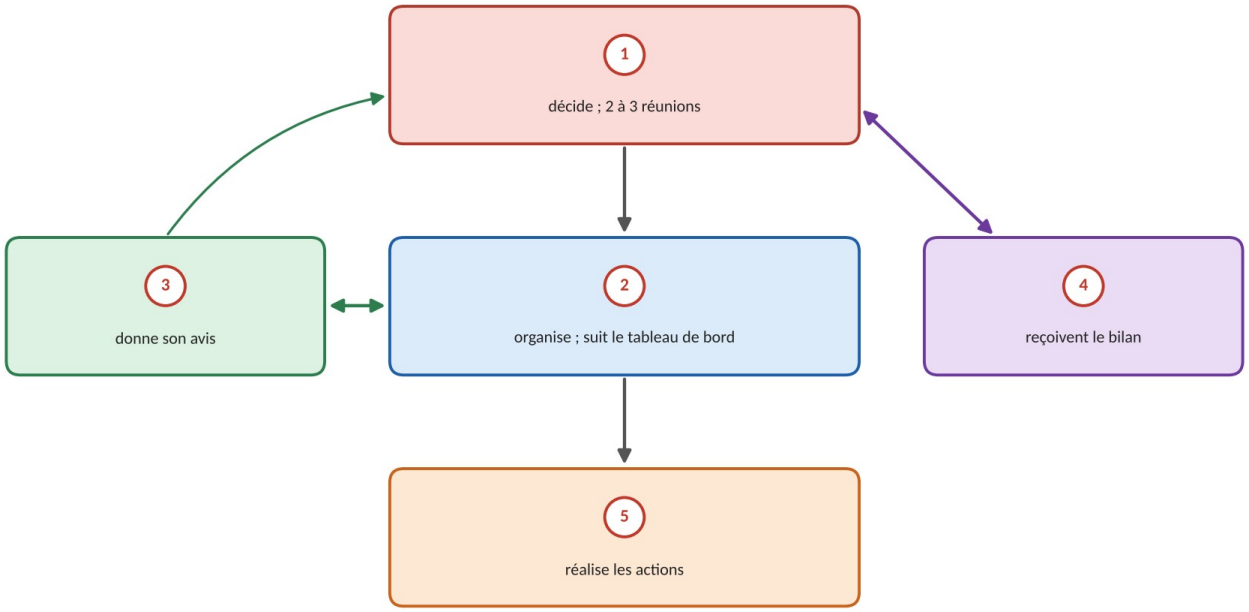


Figure 8.4 – Document 1 – L'organisation du pilotage d'un projet (schéma à légender)

Document 2 – Personnes et structures disponibles

La responsable territoriale du bailleur ; la directrice du centre social ; la référente familles du centre social ; la diététicienne de la maison de santé ; l'amicale des locataires (présidente et deux membres) ; la gardienne de la résidence ; la chargée de mission du contrat de ville ; vous-même (stagiaire) ; la caisse d'allocations familiales (financeur) ; huit locataires volontaires.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Proposez la composition du comité de pilotage et du comité technique. (3 pts)
3. Indiquez le rôle et la fréquence de réunion de chaque instance. (2,5 pts)
4. Expliquez pourquoi il est utile que l'amicale des locataires siège au comité de pilotage, et non seulement au comité d'usagers. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.9 – Corriger une matrice RACI (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association d'aide aux devoirs Coup de Pouce Saint-Rémi (fictive) accueille 40 enfants de 6 à 11 ans après l'école et leur sert un goûter. Elle lance un projet « goûters équilibrés et faits ensemble ». La coordinatrice a rempli une matrice RACI et vous demande de la vérifier.

Document 1 – La matrice RACI proposée

Tâche	Coordinatrice	Stagiaire en diététique	Animateurs (3)	Parents volontaires	Bureau de l'association
Diagnostic (goûters servis, avis des enfants)	A	R	C	C	A
Choix des goûters du trimestre	C	C	C	C	I
Achats des denrées	R	I	R	–	A
Préparation des goûters avec les enfants	A	C	R	R	–
Animation d'un atelier « goût » par mois	I	–	C	–	–
Évaluation (questionnaire, relevé des goûters)	A	R	C	I	I
Validation du budget	C	–	–	–	A

À vous de jouer – Questions

1. Rappelez la signification des quatre lettres et les deux règles de construction d'une matrice RACI. (3 pts)
2. Repérez les trois tâches qui ne respectent pas ces règles et expliquez l'erreur. (3 pts)
3. Proposez une matrice corrigée. (4 pts)
4. Expliquez l'intérêt de la matrice RACI pour un projet qui associe des bénévoles et des parents. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.10 – Corriger une convention de partenariat (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

La maison des jeunes et de la culture (MJC) des Rives (fictive) organise un cycle de six ateliers « cuisiner à 15 ans » pour des adolescents. Un supermarché voisin propose d'offrir les denrées. Son responsable a envoyé un projet de convention. La directrice de la MJC vous demande votre avis avant de signer.

Document 1 – Projet de convention (extraits)

Article 1 – Objet : « Le supermarché soutient les activités de la MJC. »

Article 2 – Engagements de la MJC : « La MJC fait apparaître le logo du supermarché sur tous ses supports, y compris les fiches recettes remises aux jeunes. Les recettes utilisent les produits de la marque du distributeur. »

Article 3 – Engagements du supermarché : « Le supermarché fournit des denrées. »

Article 4 – Données : « La MJC transmet la liste des participants et leurs adresses électroniques pour l'envoi d'offres promotionnelles. »

Article 5 – Durée : « La convention est conclue sans limite de durée. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez les cinq faiblesses de ce projet de convention. (5 pts)
2. Réécrivez les articles 1, 3 et 4. (4 pts)
3. Citez les articles qui manquent dans cette convention. (2 pts)
4. La directrice doit-elle refuser le partenariat ? Donnez votre avis argumenté. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.11 – Convaincre un partenaire réticent (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle courte · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans la zone d'activités des Trois-Chênes (fictive), le service de prévention et de santé au travail interentreprises veut lancer un projet sur le déjeuner des salariés. La plupart déjeunent au restaurant interentreprises, géré par un prestataire. Le chef de cuisine est réticent : « Encore un projet qui va me dire que ma cuisine est trop grasse. » Votre tutrice vous demande de préparer l'entretien avec lui.

Document 1 – Données utiles (fictives, 2026)

- Le restaurant sert en moyenne 420 repas par jour, 5 jours par semaine.
- Le relevé des retours de plateaux montre que 31 % des accompagnements de légumes sont jetés.
- Le prestataire a perdu 8 % de couverts en un an, au profit des boulangeries et de la livraison.
- Le projet demande au chef : 2 réunions d'une heure et demie, la co-animation de 3 dégustations d'une heure, la mise au point de 4 recettes (2 heures chacune).
- Coût horaire chargé du chef, communiqué par le prestataire : 27 €.

À vous de jouer – Questions

1. Identifiez ce que le projet peut apporter au chef et au prestataire. (3 pts)

2. Calculez le temps demandé au chef et sa valorisation. Dites dans quels comptes du budget du projet elle apparaît si le prestataire ne facture pas ce temps. (3 pts)

3. Les 420 repas actuels correspondent à la fréquentation après la baisse de 8 %. Calculez le nombre de couverts perdus chaque jour en un an (arrondi à l'unité) et le nombre de repas que ces pertes représentent sur une semaine. (2 pts)

4. Rédigez les trois premières phrases que vous direz au chef pour ouvrir l'entretien. (2 pts)

5. Proposez deux engagements réciproques à inscrire dans une convention. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.12 – Rédiger le compte rendu d'une réunion de pilotage (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

La maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) de la Haute-Sorne (fictive) conduit un projet de six ateliers pour des patients à risque de diabète. Vous avez assisté au comité de pilotage de mi-parcours et vous devez en rédiger le compte rendu.

Document 1 – Vos notes de réunion, 14 janvier 2027, 18 h – 19 h 30, salle de réunion de la MSP

Présents : Dr Mallet (médecin coordinateur), Mme Bataille (infirmière Asalée), M. Ortiz (diététicien), Mme Leroux (patiente représentante), vous-même. Excusées : Mme Faure (pharmacienne), Mme Henri (chargée de mission du contrat local de santé).

- Dr Mallet ouvre la séance, rappelle l'objectif : 3 ateliers sur 6 réalisés.
- Mme Bataille : 36 places possibles pour les 3 ateliers (12 par atelier) ; 25 présences. Deux patients ont arrêté à cause de l'horaire (14 h).
- M. Ortiz : le budget est consommé à 41 % (820 € sur 2 000 €). La salle de cuisine du lycée hôtelier n'est plus disponible en mars.
- Mme Leroux : « Les patients aimeraient un atelier le samedi matin. Et la fiche sur les étiquettes est trop petite pour les lire. »
- Décision : les ateliers 4 à 6 auront lieu le samedi de 10 h à 12 h 30. M. Ortiz cherche une autre cuisine avant le 31 janvier. Mme Bataille rappelle les patients absents d'ici le 21 janvier. La fiche sera réimprimée en grands caractères par vous, avant le 28 janvier. Mme Leroux relit la nouvelle fiche.
- Prochaine réunion : jeudi 6 mai 2027, 18 h, même salle (bilan final).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de présence aux trois premiers ateliers et commentez-le au regard de l'objectif de 80 %. (2 pts)

2. Comparez la consommation du budget à l'avancement du projet. (2 pts)

3. Rédigez le compte rendu complet de la réunion, avec un relevé des actions sous forme de tableau. (8 pts)

4. Dites à qui vous envoyez le compte rendu, et dans quel délai. (2 pts)

5. Expliquez ce qu'apporte la présence d'une patiente représentante au comité de pilotage. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 8.7

1. Légendes : 1 Satisfaire (pouvoir fort, intérêt faible) ; 2 Gérer étroitement (pouvoir fort, intérêt fort) ; 3 Surveiller (pouvoir faible, intérêt faible) ; 4 Associer et informer (pouvoir faible, intérêt fort).
2. Placement (exemple justifié) :

Quadrant	Parties prenantes
Gérer étroitement	a) maire et conseil municipal (financent et décident) ; j) directrice du CCAS (copilote) ; d) association des bénévoles (gère le réfrigérateur, peut tout arrêter)
Satisfaire	b) DDPP (peut interdire si l'hygiène n'est pas respectée, mais n'est pas porteuse) ; g) fondation (peut financer, intérêt encore faible)
Associer et informer	c) habitants utilisateurs (premiers concernés) ; e) supermarché donateur (intérêt fort : réduire le gaspillage, pouvoir limité sur le projet)
Surveiller	f) riverains ; h) journal local ; i) boulangerie hésitante

On accepte d'autres placements s'ils sont justifiés : les bénévoles peuvent aussi être placés en « associer » ; les riverains peuvent devenir un risque (plaintes pour le bruit ou les déchets).

3. Habitants : les inviter à choisir l'emplacement et les règles d'usage, créer un petit groupe d'utilisateurs qui fait remonter les problèmes, afficher les règles avec des pictogrammes. Riverains : les informer avant l'installation (courrier, rencontre), leur donner un contact en cas de problème, les inviter à l'inauguration.
4. Les positions changent : la boulangerie (i), aujourd'hui hésitante, peut devenir donatrice et passer en « associer » ; la fondation (g) peut accorder un financement et prendre un intérêt fort. La matrice se met à jour à chaque comité de pilotage.

Corrigé – Exercice 8.8

1. Légendes : 1 Comité de pilotage ; 2 Comité technique ; 3 Comité d'usagers ; 4 Financeurs ; 5 Équipe d'animation.
2. Comité de pilotage (exemple) : la responsable territoriale du bailleur, la directrice du centre social, la chargée de mission du contrat de ville, la présidente de l'amicale des locataires, un représentant de la CAF (financeur), la diététicienne. Comité technique : la référente familles, la diététicienne, la gardienne, vous-même, un membre de l'amicale.
3. Comité de pilotage : il valide les objectifs, le budget et les grandes décisions, et arbitre en cas de difficulté ; 3 réunions (lancement, mi-parcours, bilan). Comité technique : il organise les ateliers, suit le tableau de bord et prépare les décisions du comité de pilotage ; une réunion par mois. Comité d'usagers (les huit locataires volontaires) : il donne son avis sur les thèmes, les horaires, les recettes et les supports ; une réunion avant chaque série d'ateliers.
4. Au comité d'usagers, les locataires donnent un avis ; au comité de pilotage, ils participent aux **décisions** (budget, priorités). La présence de l'amicale garantit que les choix tiennent compte de la vie réelle de la résidence, renforce la légitimité du projet et favorise la mobilisation des autres locataires. C'est un niveau de participation plus élevé.

Corrigé – Exercice 8.9

1. R : réalise la tâche ; A : approuve et rend compte du résultat ; C : consulté avant la décision ; I : informé du résultat. Règles : **un seul A par tâche** ; **au moins un R par tâche**.
2. Diagnostic : **deux A** (coordinatrice et bureau) : on ne sait pas qui valide. Choix des goûters : **aucun R ni A** : personne n'est chargé de choisir. Animation de l'atelier « goût » : **aucun R ni A** : personne ne l'anime.

(Les autres lignes respectent les règles ; la ligne « achats » a deux R, ce qui est permis.)

3. Matrice corrigée (exemple) :

Tâche	Coordinatrice	Stagiaire	Animateurs	Parents	Bureau
Diagnostic	A	R	C	C	I
Choix des goûters du trimestre	A	R	C	C	I
Achats des denrées	R	I	R	–	A
Préparation des goûters avec les enfants	A	C	R	R	–
Animation d'un atelier « goût » par mois	A	R	C	I	–
Évaluation	A	R	C	I	I
Validation du budget	C	–	–	–	A

4. Quand des bénévoles, des parents et des salariés travaillent ensemble, les rôles sont flous et chacun peut croire qu'un autre s'occupe d'une tâche. La matrice rend visible qui fait quoi, évite les oublis et les doublons, et permet aux parents de savoir quand ils sont consultés et quand ils sont seulement informés.

Corrigé – Exercice 8.10

1. Faiblesses : article 1, objet flou (aucune action, aucune période) ; article 2, logo sur les fiches recettes et recettes imposées avec la marque du distributeur : c'est de la publicité auprès de mineurs et une perte d'indépendance ; article 3, engagement vague (quelles denrées, quelle quantité, quel montant ?) ; article 4, transmission de données personnelles de mineurs à des fins commerciales, contraire au RGPD et à l'éthique ; article 5, durée illimitée, sans possibilité de sortie.

2. Article 1 : « La présente convention définit les modalités du soutien du supermarché au cycle de six ateliers "cuisiner à 15 ans" organisé par la MJC des Rives de janvier à juin 2027. » Article 3 : « Le supermarché fournit gratuitement les denrées des six ateliers, dans la limite de 60 € par atelier, selon la liste transmise par la MJC une semaine avant chaque atelier. Le choix des recettes et des produits reste de la seule responsabilité de la MJC. » Article 4 : « Aucune donnée personnelle des participants n'est transmise au supermarché. La MJC transmet un bilan agrégé et anonyme du cycle. »

3. Il manque : la communication (mention sobre du soutien, par exemple « avec le soutien de… » sur l'affiche, jamais sur les supports éducatifs, validation commune) ; le suivi et l'évaluation (point à mi-parcours, bilan) ; la modification et la résiliation (avenant, préavis) ; les signatures des représentants légaux.

4. Non : le partenariat avec un commerce local peut être utile (accès aux produits, ancrage dans le quartier). La directrice doit en revanche refuser ce texte et proposer une convention qui protège l'indépendance pédagogique et les données des jeunes. Si le supermarché refuse ces conditions, elle renonce au partenariat.

Corrigé – Exercice 8.11

1. Apports : pour le chef, la reconnaissance de son savoir-faire (il co-anime et crée les recettes), moins de légumes jetés (31 % aujourd'hui), un travail valorisé auprès des salariés ; pour le prestataire, un argument pour reconquérir des couverts (− 8 % en un an), une image d'entreprise engagée, des économies sur les denrées jetées.

2. Temps : 2 × 1,5 + 3 × 1 + 4 × 2 = 3 + 3 + 8 = **14 heures** ; valorisation : 14 × 27 = **378 €**. Si le prestataire ne facture pas ce temps, c'est une **contribution volontaire en nature** : 378 € au **compte 86** (emplois, côté charges) et 378 € au **compte 87** (contributions, côté produits).

3. Les 420 repas correspondent à la situation actuelle après une perte de 8 % : les repas d'il y a un an étaient

420 / 0,92 = 456,5, soit environ **457 repas** ; perte : 457 − 420 = **37 couverts par jour** (36,5 arrondi). Sur une semaine de 5 jours : 36,5 × 5 = 182,6, soit environ **183 repas**. On accepte aussi le calcul simplifié 420 × 0,08 = 33,6, soit 34 couverts par jour et 168 par semaine, s'il est expliqué.

4. Exemple : « Merci de me recevoir. Je ne viens pas juger votre cuisine : je viens vous demander votre aide, parce que vous connaissez mieux que personne ce que les salariés mangent et ce qu'ils laissent. Nous aimerions construire avec vous quelques recettes de légumes qui reviennent moins sur les plateaux. »

5. Exemples : le service de santé au travail s'engage à présenter le chef comme co-auteur des recettes et à financer les supports de dégustation ; le prestataire s'engage à proposer les quatre recettes au menu au moins une fois par mois et à transmettre le relevé des retours de plateaux chaque mois.

Corrigé – Exercice 8.12

1. Taux de présence : 25 / 36 × 100 = **69,4 %**. Il est inférieur à l'objectif de 80 % (écart de 10,6 points). Les abandons liés à l'horaire de 14 h expliquent une partie de l'écart ; le passage au samedi matin répond à cette cause.

2. Avancement : 3 ateliers sur 6, soit 50 %. Budget consommé : 820 / 2 000 × 100 = **41 %**. La consommation est inférieure à l'avancement : il reste 2 000 − 820 = **1 180 €** pour la seconde moitié, ce qui laisse une marge, par exemple pour louer une autre cuisine.

3. Compte rendu (exemple) :

Comité de pilotage du projet « Prévenir le diabète en cuisinant » – MSP de la Haute-Sorne – jeudi 14 janvier 2027, 18 h – 19 h 30.

Présents : Dr Mallet (médecin coordinateur), Mme Bataille (infirmière Asalée), M. Ortiz (diététicien), Mme Leroux (patiente représentante), la stagiaire en diététique (rédactrice). Excusées : Mme Faure (pharmacienne), Mme Henri (chargée de mission du contrat local de santé).

Points abordés : 1. Avancement : 3 ateliers sur 6 réalisés. 2. Participation : 25 présences sur 36 possibles (69,4 %, objectif 80 %) ; deux patients ont arrêté à cause de l'horaire. 3. Budget : 820 € consommés sur 2 000 € (41 %). 4. Logistique : la cuisine du lycée hôtelier n'est plus disponible en mars. 5. Avis des patients : demande d'un atelier le samedi ; fiche « étiquettes » difficile à lire.

Décisions : les ateliers 4 à 6 auront lieu le samedi de 10 h à 12 h 30 ; la fiche « étiquettes » est réimprimée en grands caractères.

Action	Responsable	Échéance
Rappeler les patients absents	Mme Bataille	21 janvier 2027
Réimprimer la fiche « étiquettes » en grands caractères	La stagiaire	28 janvier 2027
Relire la nouvelle fiche	Mme Leroux	28 janvier 2027
Trouver une autre cuisine pour mars	M. Ortiz	31 janvier 2027

Prochaine réunion : jeudi 6 mai 2027, 18 h, salle de réunion de la MSP (bilan final).

4. À tous les membres du comité, présents **et excusés** (Mme Faure et Mme Henri doivent connaître les décisions), dans les **48 heures**, après relecture rapide par le médecin coordinateur.

5. Elle apporte le point de vue des patients (horaires, lisibilité des documents), que les professionnels n'avaient pas vu ; ses propositions ont conduit à deux décisions. Sa présence rend le projet plus acceptable et applique le principe de participation des personnes concernées.

Partie 3 – Les financements et les appels à projets

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les étapes de la réponse à un appel à projets.
- Associer un projet au financeur adapté.
- Lire un cahier des charges : éligibilité, exclusions, plafond, taux.
- Calculer une subvention et construire un plan de financement qui respecte les règles de plusieurs financeurs.
- Utiliser une grille de sélection comme un membre de comité.
- Relire un dossier de demande et repérer ses incohérences.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Appel à projets : un financeur fixe dans un cahier des charges ses priorités, ses publics, ses critères d'éligibilité et de sélection, son calendrier et son montant ; les porteurs déposent un dossier ; un comité choisit selon une grille ; le porteur retenu rend un bilan.
- Sept étapes : lire le cahier des charges ; vérifier l'éligibilité ; faire correspondre le projet aux priorités ; rédiger ; remplir le formulaire (souvent le Cerfa n° 12156 ou Le Compte Asso) ; faire relire ; déposer avant la date limite.
- Financeurs : ARS (fonds d'intervention régional, article L. 1435-8 du Code de la santé publique) ; collectivités ; CAF ; conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie (loi du 28 décembre 2015) pour les 60 ans et plus ; Assurance maladie, mutuelles, caisses de retraite ; fondations ; État (politique de la ville).
- Subvention = minimum (plafond ; taux × assiette). L'assiette est la base de calcul fixée par le financeur (souvent les dépenses éligibles, hors contributions en nature).
- Un financeur ne finance presque jamais 100 % : on montre un cofinancement et on distingue les financements acquis et sollicités.

Exercice 8.13 – Les étapes de la réponse à un appel à projets (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association Jardins de la Combe (fictive) découvre le 1er février 2027 un appel à projets dont la date limite est le lundi 15 mars 2027 à midi. Le trésorier a noté en désordre ce qu'il faut faire.

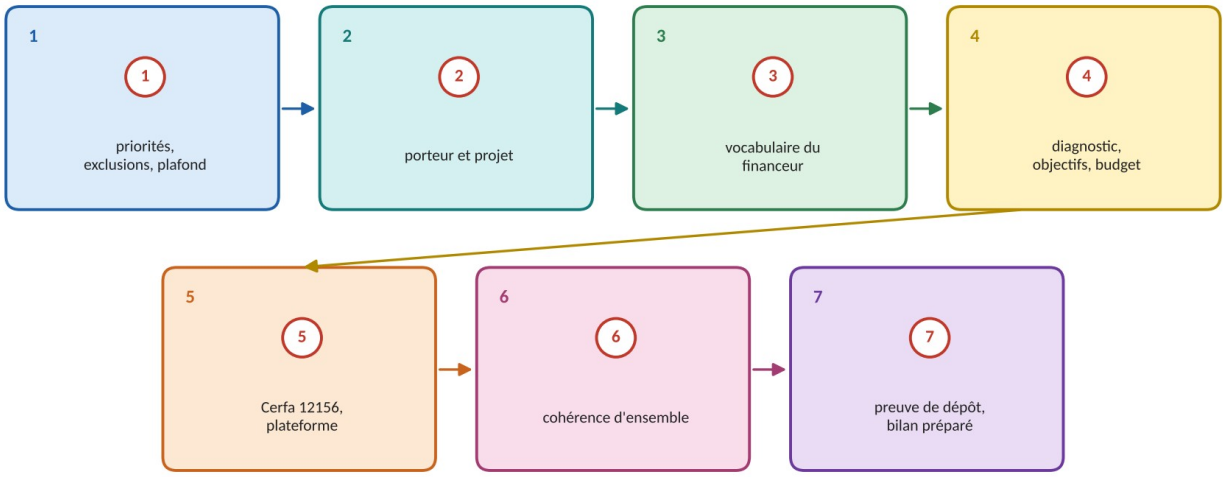


Figure 8.5 – Document 1 – Répondre à un appel à projets en sept étapes (schéma à légender)

Document 2 – Les notes du trésorier, en désordre

a) Demander à la présidente et au partenaire de relire le dossier.

b) Vérifier que l'association est déclarée, qu'elle a un numéro SIRET et un compte bancaire.

c) Créer le compte de l'association sur la plateforme et saisir le formulaire.

d) Déposer le dossier et enregistrer l'accusé de réception.

e) Lire tout le cahier des charges et surligner les actions exclues.

f) Rédiger le diagnostic, les objectifs, les actions et le budget.

g) Reprendre les mots du financeur : « publics prioritaires », « réduction des inégalités ».

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)
2. Remettez les notes du document 2 dans l'ordre des sept étapes. (3,5 pts)
3. Proposez une date de dépôt et justifiez-la. (1,5 pt)
4. Expliquez pourquoi il faut préparer le bilan dès le dépôt du dossier. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.14 – Qui finance quoi ? (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une réunion du réseau des diététiciens de prévention d'un département, chacun présente un projet en recherche de financement. Vous devez proposer, pour chaque projet, le financeur le plus adapté.

Document 1 – Huit projets en recherche de financement

a) Des ateliers « bien manger après 70 ans » dans trois résidences autonomie.

b) Des ateliers parents-enfants dans un centre social, dans le cadre de l'animation collective familles.

c) Un programme de prévention de l'obésité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, inscrit dans le contrat de ville.

d) Des actions de nutrition pour des personnes en situation de précarité, inscrites dans le projet régional de santé.

e) L'amélioration des menus de la restauration scolaire d'une commune.

f) Un projet innovant de cuisine mobile pour les zones rurales isolées.

g) Des ateliers « retraite active et alimentation » pour des retraités du régime général qui vivent à domicile.

h) Un programme d'éducation thérapeutique pour des patients diabétiques, déclaré à l'ARS.

À vous de jouer – Questions

1. Proposez un financeur pour chaque projet et justifiez en une ligne. (8 pts)

2. Pour le projet f), citez une précaution à prendre si le financeur est une fondation d'entreprise. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.15 – Lire un cahier des charges (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le conseil départemental de Brenne-et-Loir (collectivité fictive) publie un appel à projets « Bien manger en Brenne-et-Loir 2027 ». La date limite de dépôt est le 31 mars 2027. Vous aidez une animatrice territoriale de santé à analyser cinq projets avant de conseiller leurs porteurs.

Document 1 – Extraits du cahier des charges (fictif)

- Porteurs éligibles : associations déclarées depuis au moins un an à la date limite de dépôt ; communes ; CCAS.
- Publics prioritaires : familles avec au moins un enfant de moins de 6 ans ; personnes de 60 ans et plus vivant à domicile.
- Actions éligibles : actions collectives d'éducation pour la santé, actions sur l'environnement alimentaire.
- Actions exclues : consultations individuelles ; distribution de denrées seule ; investissements de plus de 500 € par équipement.
- Durée : 12 mois au plus.
- Montant : 50 % au plus des dépenses éligibles (dépenses monétaires hors investissements exclus), dans la limite de 4 000 € par projet.

Document 2 – Cinq projets

Projet	Porteur	Contenu	Durée	Budget total (dont contributions en nature)
P1	Association créée en 2019	8 ateliers parents-enfants de moins de 6 ans	10 mois	7 200 € (900 €)
P2	Association créée en mai 2026	Ateliers culinaires pour des seniors à domicile	9 mois	5 000 € (400 €)
P3	CCAS	Consultations diététiques individuelles pour les plus de 60 ans	12 mois	6 000 € (0 €)
P4	Commune	Jardins partagés et ateliers pour les familles	18 mois	8 500 € (1 200 €)
P5	Association créée en 2010	Ateliers dans un club de seniors, dont l'achat d'un four à 650 €	12 mois	11 000 € (1 000 €)

À vous de jouer – Questions

1. Dites si chaque projet est éligible, et justifiez. (5 pts)

2. Calculez la subvention maximale du projet P1. (2 pts)

3. Calculez la subvention maximale du projet P5, en tenant compte de l'achat du four. (3 pts)

4. Proposez un conseil au porteur du projet P4 pour qu'il puisse déposer un dossier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.16 – Construire un plan de financement (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association Âge d'Or en Cuisine (fictive) prépare huit ateliers « bien manger chez soi » pour 15 personnes de plus de 60 ans vivant à domicile. Le coût total du projet est de 9 600 €, dont 1 200 € de contributions en nature (bénévolat et salle prêtée). Vous construisez le plan de financement.

Document 1 – Règles des financeurs (fictives)

- Conférence des financeurs : 60 % au plus des charges monétaires, dans la limite de 5 000 €.
- Caisse de retraite : 1 500 € au plus.
- Commune : 1 000 €, déjà accordés (financement acquis).
- Participation des personnes : 2 € par atelier et par personne.
- Exigence de la conférence des financeurs : l'autofinancement de l'association doit représenter au moins 10 % des charges monétaires.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les charges monétaires du projet. (1 pt)
2. Calculez la subvention maximale de la conférence des financeurs et la participation totale des personnes. (2 pts)
3. Si l'on demande le maximum à chaque financeur, calculez l'autofinancement nécessaire et vérifiez la règle des 10 %. (3 pts)
4. Proposez un plan de financement équilibré qui respecte toutes les règles, sous forme de tableau, contributions en nature comprises. (4 pts)
5. Indiquez quels financements sont acquis et lesquels sont sollicités, et pourquoi il faut le préciser. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.17 – Évaluer des dossiers avec une grille de sélection (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice siège au comité de sélection d'un appel à projets intercommunal (fictif) doté de 8 000 €. Elle vous demande de préparer la notation de trois dossiers. Chaque critère est noté de 0 à 4 ; les points obtenus sont égaux au poids × note / 4. Un dossier doit obtenir au moins 60 points sur 100 pour être financé.

Document 1 – Grille et notes proposées

Critère	Poids	Dossier X	Dossier Y	Dossier Z
Diagnostic chiffré et sourcé	20	3	4	2
Objectifs SMART reliés aux constats	15	2	4	1
Public prioritaire	15	4	2	3
Qualité et cohérence des actions	20	3	3	2
Partenariats engagés	10	2	4	1
Évaluation prévue	10	1	3	0
Budget équilibré et cofinancé	10	3	2	2

Document 2 – Montants demandés

Dossier X : 3 500 € (familles en quartier prioritaire). Dossier Y : 4 000 € (salariés d'une zone d'activités). Dossier Z : 3 000 € (jeunes d'un foyer rural).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de points de chaque dossier, critère par critère, puis le total. (5 pts)
2. Indiquez les dossiers qui peuvent être financés et vérifiez l'enveloppe. (2 pts)
3. Le dossier X touche le public le plus prioritaire mais prévoit mal son évaluation. Rédigez le conseil que le comité peut lui adresser. (2 pts)
4. Rédigez deux conseils au porteur du dossier Z pour un prochain dépôt. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.18 – Relire un dossier de demande de subvention (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une collègue a rédigé la réponse de l'association Tables Ouvertes (fictive) à un appel à projets de l'ARS (fictif) dont le plafond est de 3 500 € par projet. Le public prioritaire de l'appel à projets est : « personnes en situation de précarité ». Elle vous demande une relecture critique avant le dépôt.

Document 1 – Extraits du dossier

Contexte : « Beaucoup de personnes ont du mal à bien manger dans notre ville. »

Public : « Tout public. »

Objectif : « Sensibiliser la population à l'équilibre alimentaire. »

Actions : « Six ateliers de cuisine et une conférence. »

Évaluation : « Un questionnaire de satisfaction. »

Calendrier : « De janvier 2027 à juin 2028. »

Document 2 – Budget prévisionnel du dossier

Charges	Montant	Produits	Montant
60 – Achats (denrées, petit matériel)	1 240 €	74 – Subvention ARS sollicitée	4 000 €
62 – Honoraires d'une diététicienne	2 100 €	74 – Commune (acquise)	1 500 €
64 – Personnel (coordination)	3 600 €	70 – Participation des personnes	300 €
86 – Bénévolat valorisé	800 €	87 – Bénévolat valorisé	600 €
		Autofinancement	1 140 €
Total	7 740 €	Total	7 540 €

Phrase du dossier : « La subvention ARS représente 45 % du budget total. »

À vous de jouer – Questions

1. Repérez les faiblesses du texte (document 1) et proposez une correction pour chacune. (6 pts)
2. Vérifiez le budget : totaux, équilibre, comptes 86 et 87. (3 pts)
3. Calculez la part réelle de la subvention de l'ARS dans le budget et comparez-la au plafond. (3 pts)
4. Proposez un budget corrigé, équilibré, qui respecte le plafond, sans changer les charges. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 8.13

1. Légendes : 1 Lire le cahier des charges ; 2 Vérifier l'éligibilité ; 3 Faire correspondre ; 4 Rédiger ; 5 Remplir le formulaire ; 6 Faire relire ; 7 Déposer avant la date.
2. Ordre : e) lire le cahier des charges → b) vérifier l'éligibilité → g) reprendre les mots du financeur → f) rédiger → c) saisir le formulaire sur la plateforme → a) faire relire → d) déposer et garder l'accusé de réception.
3. Exemple : déposer le **mercredi 10 mars 2027**, soit quelques jours avant la date limite, pour faire face à une panne de la plateforme, à une pièce manquante (relevé d'identité bancaire, statuts) ou à une signature en retard. Un dépôt le dernier jour expose au refus si un incident survient.
4. Le financeur demandera un bilan (compte rendu d'activité et compte rendu financier) avec les indicateurs annoncés dans le dossier. Si l'on ne recueille pas les données dès le début (présences, questionnaires « avant »), on ne pourra pas les reconstituer à la fin.

Corrigé – Exercice 8.14

1. Propositions :

Projet	Financeur	Justification
a) Ateliers en résidences autonomie	Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie	Prévention pour les 60 ans et plus (loi du 28 décembre 2015) ; les résidences autonomie en relèvent
b) Ateliers parents-enfants	CAF	Animation collective familles des centres sociaux, soutien à la parentalité
c) Quartier prioritaire	État (crédits de la politique de la ville) et commune	Action inscrite dans le contrat de ville
d) Nutrition et précarité	ARS (fonds d'intervention régional)	Prévention conforme au projet régional de santé, publics prioritaires
e) Menus de la cantine	Commune	La restauration scolaire du premier degré relève de la commune
f) Cuisine mobile en zone rurale	Fondation, ou programme européen de développement rural	Projet innovant ; les fondations financent souvent l'innovation
g) Retraités du régime général	Caisse de retraite (action sociale)	Prévention « bien vieillir » pour ses retraités à domicile
h) Éducation thérapeutique	ARS	Depuis le décret du 31 décembre 2020, les programmes d'ETP sont déclarés à l'ARS ; ils peuvent être financés par le fonds d'intervention régional

2. Vérifier l'absence de **conflit d'intérêts** : la fondation ne doit pas imposer ses produits, son logo sur les supports éducatifs ou ses messages ; prévoir une convention qui garantit l'indépendance du contenu et la transparence du financement (chapitre 6).

Corrigé – Exercice 8.15

1. P1 : **éligible** (association de plus d'un an, public prioritaire des familles avec enfants de moins de 6 ans, action collective, 10 mois). P2 : **non éligible** : l'association a été créée en mai 2026, elle aura moins d'un an au 31 mars 2027. P3 : **non éligible** : les consultations individuelles sont exclues. P4 : **non éligible en l'état** : 18 mois dépasse la durée maximale de 12 mois. P5 : **éligible**, mais l'achat du four (650 €, plus de 500 €) est exclu des dépenses éligibles.

2. P1 : dépenses éligibles = 7 200 − 900 = **6 300 €** ; 50 % × 6 300 = **3 150 €** ; inférieur au plafond de 4 000 € : subvention maximale **3 150 €**.

3. P5 : dépenses éligibles = 11 000 − 1 000 − 650 = **9 350 €** ; 50 % × 9 350 = **4 675 €** ; supérieur au plafond : subvention maximale **4 000 €**. Le four doit être financé autrement (fonds propres, autre financeur).

4. Découper le projet : déposer une première phase de 12 mois au plus (par exemple la création des jardins et les ateliers de la première saison), puis une seconde phase l'année suivante ; ou réduire la durée du projet à 12 mois.

Corrigé – Exercice 8.16

1. Charges monétaires : 9 600 − 1 200 = **8 400 €**.

2. Conférence des financeurs : 60 % × 8 400 = 5 040 €, supérieur au plafond : **5 000 €**. Participation : 2 € × 8 ateliers × 15 personnes = **240 €**.

3. Financements maximaux : 5 000 + 1 500 + 1 000 + 240 = **7 740 €** ; autofinancement nécessaire : 8 400 − 7 740 = **660 €**, soit 660 / 8 400 × 100 = **7,9 %** : la règle des 10 % **n'est pas respectée**. Il faut au moins 10 % × 8 400 = **840 €** d'autofinancement.

4. On porte l'autofinancement à 840 € et l'on réduit d'autant la demande à la caisse de retraite : 8 400 − 5 000 − 1 000 − 240 − 840 = **1 320 €**.

Produits	Montant	Statut
74 – Conférence des financeurs	5 000 €	Sollicité
74 – Caisse de retraite	1 320 €	Sollicité
74 – Commune	1 000 €	Acquis
70 – Participation des personnes	240 €	Prévu
Autofinancement de l'association	840 €	Acquis
87 – Contributions volontaires en nature	1 200 €	Prévu
Total	**9 600 €**	

Vérification : 5 000 + 1 320 + 1 000 + 240 + 840 = 8 400 € de produits monétaires, plus 1 200 € de contributions en nature (comptes 86 et 87 égaux) = 9 600 €, égal aux charges.

5. Acquis : la commune (déjà accordée) et l'autofinancement. Sollicités : la conférence des financeurs et la caisse de retraite. Le financeur doit savoir ce qui est certain et ce qui dépend d'autres décisions ; si une demande est refusée, le projet devra être réduit ou financé autrement. C'est une règle de **prudence**.

Corrigé – Exercice 8.17

1. Points (poids × note / 4) :

Critère	X	Y	Z
Diagnostic (20)	15	20	10
Objectifs (15)	7,5	15	3,75
Public prioritaire (15)	15	7,5	11,25
Actions (20)	15	15	10
Partenariats (10)	5	10	2,5
Évaluation (10)	2,5	7,5	0
Budget (10)	7,5	5	5
Total	**67,5**	**80**	**42,5**

2. X (67,5) et Y (80) dépassent le seuil de 60 points ; Z (42,5) ne l'atteint pas. Enveloppe : 3 500 + 4 000 = **7 500 €** ≤ 8 000 € : les deux dossiers peuvent être financés ; il reste 500 €.

3. Exemple : « Le comité retient votre projet, qui touche un public prioritaire. Il vous demande de préciser avant le premier versement les indicateurs d'évaluation (présence, questionnaire avant/après sur les pratiques), leurs valeurs cibles et la façon de les recueillir. »

4. Exemples : appuyer le diagnostic sur des données locales chiffrées et datées (enquête auprès des jeunes du foyer, données de la structure) ; rédiger des objectifs SMART reliés aux constats et prévoir des indicateurs d'évaluation ; joindre des lettres d'engagement des partenaires.

Corrigé – Exercice 8.18

1. Faiblesses et corrections :

Élément	Faiblesse	Correction
Contexte	Aucune donnée, aucune source	Données locales chiffrées et datées (Insee, enquête auprès des personnes accueillies)
Public	« Tout public » : ne correspond pas au public prioritaire	Personnes en situation de précarité accueillies par l'association, nombre prévu
Objectif	« Sensibiliser » : verbe flou, non mesurable	Objectifs SMART, par exemple : « Dans 12 mois, 50 % des participants cuisinent un repas à base de légumes au moins deux fois par semaine (valeur initiale à mesurer) »
Actions	Pas de détail ; la conférence convient mal au public	Fiche QQOQCCP de chaque atelier ; remplacer la conférence par une action plus active
Évaluation	Satisfaction seulement	Indicateurs de processus (présence) et de résultats (pratiques avant/après)
Calendrier	18 mois	À vérifier dans le cahier des charges, qui limite souvent la durée à 12 mois

2. Total des charges : 1 240 + 2 100 + 3 600 + 800 = **7 740 €** (exact). Total des produits : 4 000 + 1 500 + 300 + 600 + 1 140 = **7 540 €** (exact). Le budget **n'est pas équilibré** : il manque 200 €. La cause : le compte 87 (600 €) n'est pas égal au compte 86 (800 €).

3. Part réelle : 4 000 / 7 740 × 100 = **51,7 %**, et non 45 %. De plus, 4 000 € **dépasse le plafond** de 3 500 €.

4. Budget corrigé (exemple) : charges inchangées (7 740 €). Produits : ARS 3 500 € ; commune 1 500 € ; participation 300 € ; 87 – bénévolat 800 € ; autofinancement 1 640 €. Total : 3 500 + 1 500 + 300 + 800 + 1 640 = **7 740 €**. Part de l'ARS : 3 500 / 7 740 × 100 = **45,2 %**. Si l'association ne peut pas apporter 1 640 €, elle cherche un autre cofinancement (CAF, fondation) ou réduit les charges.

Partie 4 – Planifier le projet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Lire une tâche du réseau PERT et calculer les dates au plus tôt, au plus tard et les marges.
- Construire un diagramme de Gantt avec des jalons et des contraintes de calendrier.
- Trouver le chemin critique d'un projet et la durée minimale.
- Mesurer l'effet d'un retard et décider d'un ajustement.
- Estimer la charge de travail et suivre une feuille de temps.
- Fixer des dates réelles en tenant compte des contraintes du public et des lieux.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Diagramme de Gantt (Henry Gantt, vers 1910) : les tâches en lignes, le temps en colonnes ; chaque tâche est une barre ; on ajoute les jalons (dates clés) et les dépendances.
- Réseau PERT (1958) : il représente les tâches et leurs antériorités. Calcul aller : début au plus tôt d'une tâche = maximum des fins au plus tôt des tâches qui la précèdent. Calcul retour : fin au plus tard = minimum des débuts au plus tard des tâches qui la suivent.
- Marge = début au plus tard − début au plus tôt. Chemin critique : suite des tâches de marge nulle ; sa durée est la durée minimale du projet.
- Un retard sur une tâche critique retarde tout le projet ; un retard sur une tâche qui a une marge n'a d'effet que s'il dépasse la marge.
- Marge de sécurité : 10 à 20 % sur les tâches qui dépendent d'autres personnes ; dépôt d'un dossier quelques jours avant la date limite.

Exercice 8.19 – Lire une tâche du réseau PERT (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution et application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour préparer un projet court dans une association de quartier (fictive), votre tutrice vous demande de maîtriser la lecture d'une tâche PERT, puis de calculer un petit réseau.

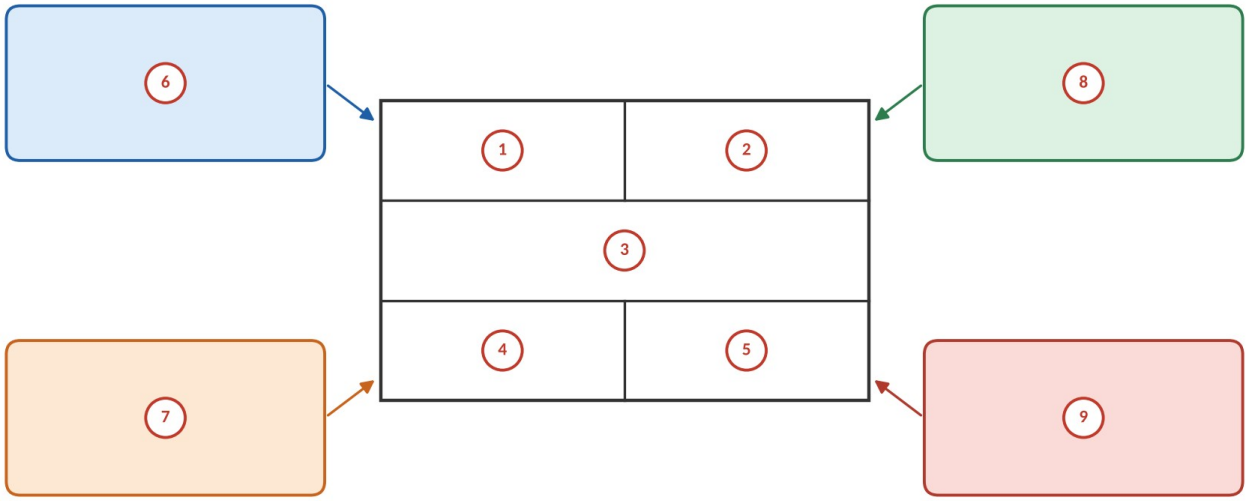


Figure 8.6 – Document 1 – Lire une tâche du réseau PERT (schéma à légender)

Document 2 – Un petit projet de cinq tâches (durées en semaines)

Tâche	Intitulé	Durée	Antériorités
A	Réunion de lancement	1	–
B	Conception des ateliers	4	A
C	Réservation de la salle et du matériel	2	A
D	Trois ateliers	3	B, C
E	Commande des fiches recettes imprimées	2	C

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)

2. Calculez les dates au plus tôt et au plus tard de chaque tâche du document 2. (3 pts)

3. Calculez les marges, donnez le chemin critique et la durée minimale du projet. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.20 – Construire un diagramme de Gantt (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre de santé communautaire du Mail (structure fictive) prépare un cycle de cinq ateliers hebdomadaires « marcher et cuisiner ». Le projet commence la semaine 1. Le centre est fermé la semaine 10 (congés du personnel). Le comité de pilotage de bilan doit se réunir au plus tard la semaine 15.

Document 1 – Les tâches du projet (durées en semaines)

Tâche	Intitulé	Durée	Antériorités
A	Diagnostic complémentaire	2	–
B	Conception des ateliers	2	A
C	Réservation de la salle et du matériel	1	A
D	Communication et inscriptions	3	B
E	Achat du petit matériel	1	C
F	Cinq ateliers, un par semaine	5	D, E
G	Évaluation et bilan	2	F

À vous de jouer – Questions

1. Indiquez pour chaque tâche la semaine de début et la semaine de fin, sans tenir compte de la fermeture. (3 pts)
2. Construisez le diagramme de Gantt sur 15 semaines en tenant compte de la fermeture de la semaine 10. (3 pts)
3. Placez trois jalons sur le diagramme. (2 pts)
4. Le comité de bilan peut-il se réunir la semaine 15 ? Justifiez. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.21 – Calculer un réseau PERT complet (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association Bocal et Compagnie (fictive) monte une épicerie itinérante qui proposera aussi des ateliers culinaires dans six villages. Le projet commence à la semaine 0. Vous devez calculer sa durée et repérer les tâches à surveiller.

Document 1 – Les tâches du projet (durées en semaines)

Tâche	Intitulé	Durée	Antériorités
A	Diagnostic dans les six villages	3	–
B	Choix des actions	1	A
C	Dossier de financement	2	B
D	Recherche de partenaires (mairies, producteurs)	3	A
E	Conception des ateliers	3	B
F	Formation des bénévoles	2	D, E
G	Communication dans les villages	1	C, E
H	Tournée et ateliers	8	F, G
I	Évaluation et bilan	2	H

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les dates de début et de fin au plus tôt de chaque tâche. (4 pts)
2. Calculez les dates de début et de fin au plus tard. (3 pts)
3. Calculez les marges, donnez le chemin critique et la durée minimale du projet. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi le dossier de financement (C) n'est pas critique, et pourquoi il faut pourtant le surveiller. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.22 – Mesurer l'effet d'un retard (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Reprenez le réseau de l'exercice 8.21 (durée minimale : 19 semaines). Au cours du projet, plusieurs incidents sont envisagés. On les étudie un par un.

Document 1 – Quatre incidents possibles

- Incident 1 : la recherche de partenaires (D) prend 5 semaines au lieu de 3, car deux mairies tardent à répondre.
- Incident 2 : le dossier de financement (C) prend 4 semaines au lieu de 2.
- Incident 3 : la formation des bénévoles (F) prend 3 semaines au lieu de 2.
- Incident 4 : la communication (G) prend 2 semaines au lieu de 1.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque incident, calculez la nouvelle durée du projet. (6 pts)

2. Pour l'incident 1, donnez le nouveau chemin critique. (2 pts)

3. Pour l'incident 2, expliquez ce qui change dans le réseau même si la durée du projet ne change pas. (2 pts)

4. Proposez une mesure pour éviter l'incident 1. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.23 – Estimer la charge de travail et suivre une feuille de temps (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

La conseillère en économie sociale et familiale (CESF) d'un centre social (fictif) anime un cycle de six ateliers culinaires. Son employeur lui demande d'estimer le temps qu'elle y consacrera, puis de le comparer au temps réel. Son coût horaire chargé, communiqué par l'employeur, est de 23 €.

Document 1 – Estimation de la charge de travail

Tâche	Base de calcul
Préparation (conducteur, fiches)	3 h par atelier
Achats	1 h par atelier
Animation	2 h 30 par atelier
Rangement et bilan à chaud	30 min par atelier
Réunions du comité technique	3 réunions d'1 h 30
Communication et inscriptions	6 h au total
Évaluation et bilan écrit	8 h au total

Document 2 – Feuille de temps réelle à la fin du cycle

Total des heures notées par la CESF : 72 heures. Elle signale que les inscriptions ont demandé de nombreux appels téléphoniques et que deux fiches recettes ont été réécrites en facile à lire et à comprendre (FALC).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre d'heures prévues pour chaque tâche et le total. (4 pts)
2. Calculez le coût prévu et le coût réel du temps de la CESF. (2 pts)
3. Calculez l'écart en heures et en pourcentage, et interprétez-le. (3 pts)
4. Expliquez l'intérêt d'une feuille de temps pour le prochain projet et pour le bilan financier. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.24 – Fixer les dates réelles d'un cycle d'ateliers (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre social des Hauts-Prés (fictif) prépare six ateliers hebdomadaires « cuisiner en famille », le mardi de 14 h à 16 h 30, pour des mères de famille du quartier. Le comité de pilotage de bilan est fixé au mardi 1er juin 2027 ; l'évaluation demande une semaine après le dernier atelier. Vous devez proposer les dates.

Document 1 – Contraintes recueillies

- Les ateliers peuvent commencer à partir du mardi 2 mars 2027.
- Plusieurs participantes jeûnent pendant le mois de Ramadan, attendu du 8 février au 9 mars 2027 environ ; elles souhaitent que le cycle commence après.
- La cuisine est réservée pour une formation le mardi 6 avril 2027.
- Le centre social est fermé du lundi 19 au vendredi 30 avril 2027 (congés du personnel, dates fictives).
- Les participantes demandent que les ateliers se suivent, sans plus de deux semaines d'interruption.

À vous de jouer – Questions

1. Proposez les six dates du cycle et justifiez chacune. (5 pts)
2. Vérifiez que le calendrier permet l'évaluation avant le comité de bilan. (2 pts)
3. Identifiez l'interruption la plus longue et proposez une action pour garder le lien avec les participantes pendant cette période. (3 pts)
4. Construisez un rétroplanning des tâches de préparation, en partant du premier atelier. (4 pts)
5. Expliquez pourquoi le calendrier doit être construit avec les participantes plutôt que pour elles. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 8.19

1. Légendes : 1 Début au plus tôt ; 2 Fin au plus tôt ; 3 Tâche et durée ; 4 Début au plus tard ; 5 Fin au plus tard ; 6 Calcul aller : on prend le maximum des fins ; 7 Calcul retour : on prend le minimum des débuts ; 8 Marge = début au plus tard − début au plus tôt ; 9 Chemin critique : tâches de marge nulle.

2. et 3. Calculs (en semaines) :

Tâche	Début au plus tôt	Fin au plus tôt	Début au plus tard	Fin au plus tard	Marge
A (1)	0	1	0	1	0
B (4)	1	5	1	5	0
C (2)	1	3	3	5	2
D (3)	max(5 ; 3) = 5	8	5	8	0
E (2)	3	5	6	8	3

Calcul retour : D et E finissent au plus tard à 8 ; C doit finir avant le début au plus tard de D (5) et de E (6) : minimum = 5. A doit finir avant le début au plus tard de B (1) et de C (3) : minimum = 1. Chemin critique : **A → B → D**, durée minimale **8 semaines** (1 + 4 + 3). C a une marge de 2 semaines, E de 3 semaines.

Corrigé – Exercice 8.20

1. A : semaines 1 à 2. B : 3 à 4. C : semaine 3. D : 5 à 7 (après B). E : semaine 4 (après C). F : 8 à 12 (après D, qui finit en semaine 7, et E). G : 13 à 14.

2. Avec la fermeture de la semaine 10, les ateliers ont lieu les semaines 8, 9, 11, 12 et 13 ; l'évaluation se fait les semaines 14 et 15.

Tâche	Semaines occupées
A – Diagnostic	1, 2
B – Conception	3, 4
C – Réservation	3
D – Communication	5, 6, 7
E – Achat du matériel	4 (marge jusqu'à la semaine 7)
F – Ateliers	8, 9, (fermeture en 10), 11, 12, 13
G – Évaluation	14, 15

3. Exemples de jalons : fin de la semaine 4, « ateliers conçus et validés » ; fin de la semaine 7, « inscriptions closes » ; fin de la semaine 13, « fin des ateliers » ; fin de la semaine 15, « comité de bilan ».

4. Oui, mais **sans aucune marge** : l'évaluation se termine en fin de semaine 15. Le comité doit se réunir à la fin de la semaine 15 ; le moindre retard d'une tâche critique (A, B, D, F, G) le reporterait. Il faut surveiller ces tâches ou prévoir de présenter un bilan provisoire.

Corrigé – Exercice 8.21

1. à 3. Calculs (en semaines) :

Tâche	Début au plus tôt	Fin au plus tôt	Début au plus tard	Fin au plus tard	Marge
A (3)	0	3	0	3	0
B (1)	3	4	3	4	0
C (2)	4	6	6	8	2

Tâche	Début au plus tôt	Fin au plus tôt	Début au plus tard	Fin au plus tard	Marge
D (3)	3	6	4	7	1
E (3)	4	7	4	7	0
F (2)	max(6 ; 7) = 7	9	7	9	0
G (1)	max(6 ; 7) = 7	8	8	9	1
H (8)	max(9 ; 8) = 9	17	9	17	0
I (2)	17	19	17	19	0

Calcul retour (exemples) : H commence au plus tard à 17 − 8 = 9 ; F et G doivent finir à 9 ; E doit finir avant le début au plus tard de F (7) et de G (8) : minimum = 7 ; B doit finir avant le début au plus tard de C (6) et de E (4) : minimum = 4 ; A doit finir avant le début au plus tard de B (3) et de D (4) : minimum = 3.

Chemin critique : **A → B → E → F → H → I**, soit 3 + 1 + 3 + 2 + 8 + 2 = **19 semaines**.

4. C a une marge de 2 semaines : il peut glisser de 2 semaines sans retarder le projet. Mais un dossier de financement dépend d'une date limite fixée par le financeur et d'une réponse qui conditionne les achats et la trésorerie : un retard au-delà de la marge, ou un refus, compromettrait toute la tournée. On le surveille donc comme une tâche à risque.

Corrigé – Exercice 8.22

1. Incident 1 (D = 5) : D finit à 3 + 5 = 8 ; F commence à max(8 ; 7) = 8 et finit à 10 ; H : 10 à 18 ; I : 18 à 20. **Durée : 20 semaines** (+ 1 semaine : la marge de D, 1 semaine, absorbe une partie du retard). Incident 2 (C = 4) : C finit à 8 ; G commence à max(8 ; 7) = 8 et finit à 9 ; H commence toujours à 9. **Durée : 19 semaines** (la marge de C, 2 semaines, absorbe le retard). Incident 3 (F = 3) : F est critique ; F finit à 10 ; **durée : 20 semaines**. Incident 4 (G = 2) : G finit à 9 ; H commence toujours à 9 ; **durée : 19 semaines** (marge de G : 1 semaine).
2. Incident 1 : nouveau chemin critique **A → D → F → H → I** (3 + 5 + 2 + 8 + 2 = 20 semaines). B et E ne sont plus critiques (marge d'une semaine).
3. Incident 2 : la marge de C est entièrement consommée ; C et G deviennent **critiques** (il existe alors un second chemin critique A → B → C → G → H → I de 19 semaines). Le moindre retard supplémentaire sur C ou G retarderait tout le projet.
4. Exemples : contacter les mairies dès la fin du diagnostic, avec un courrier et un rendez-vous fixé à l'avance ; s'appuyer sur un élu relais ; prévoir une relance à date fixe ; démarrer la recherche de partenaires en parallèle de la fin du diagnostic.

Corrigé – Exercice 8.23

1. Préparation : 6 × 3 = **18 h** ; achats : 6 × 1 = **6 h** ; animation : 6 × 2,5 = **15 h** ; rangement : 6 × 0,5 = **3 h** ; réunions : 3 × 1,5 = **4,5 h** ; communication : **6 h** ; évaluation : **8 h**. Total : 18 + 6 + 15 + 3 + 4,5 + 6 + 8 = **60,5 heures**.
2. Coût prévu : 60,5 × 23 = **1 391,50 €** ; coût réel : 72 × 23 = **1 656,00 €**.
3. Écart : 72 − 60,5 = **+ 11,5 heures**, soit 11,5 / 60,5 × 100 = **+ 19,0 %** (264,50 € de plus). Le temps a été sous-estimé, surtout pour les inscriptions (appels téléphoniques) et pour l'adaptation des fiches en FALC. Ces tâches sont réelles et utiles ; il faut les prévoir dans le prochain projet.
4. La feuille de temps permet de mieux estimer les prochains projets (on connaît le temps réel par tâche), de justifier les charges de personnel dans le compte rendu financier remis au financeur, et de repérer les tâches qui prennent plus de temps que prévu pour les organiser autrement.

Corrigé – Exercice 8.24

1. Dates proposées : **mardi 16 mars** (premier mardi après la fin du Ramadan, le 9 mars environ ; le 2 et le 9 mars sont exclus) ; **23 mars** ; **30 mars** ; le 6 avril est exclu (formation) ; **13 avril** ; les 20 et 27 avril sont exclus (fermeture du centre) ; **4 mai** ; **11 mai 2027**.

2. Dernier atelier le 11 mai ; évaluation du 12 au 18 mai ; il reste deux semaines avant le comité du 1er juin. Le calendrier convient, avec une marge de deux semaines.

3. L'interruption la plus longue va du 13 avril au 4 mai : trois semaines entre deux ateliers, soit deux mardis sans atelier, ce qui respecte tout juste la demande des participantes. Pour garder le lien : un défi « recette à la maison » donné le 13 avril, avec une photo du plat à partager si elles le souhaitent, et un message de rappel la veille du 4 mai.

4. Rétroplanning (exemple) :

Échéance	Tâche
Semaine du 8 février	Réunion avec trois participantes pour choisir les thèmes et les dates
Semaine du 15 février	Réservation de la cuisine pour les six dates ; vérification du matériel
Semaine du 22 février	Affiches et bouche-à-oreille ; début des inscriptions
Semaine du 1er mars	Conducteurs et fiches recettes des trois premiers ateliers ; recueil des allergies
Vendredi 12 mars	Achats du premier atelier ; confirmation des inscriptions
Lundi 15 mars	Rappel téléphonique aux participantes

5. Les participantes connaissent leurs contraintes (jeûne, enfants, travail, transports) ; un calendrier construit avec elles réduit les absences et montre que leur avis compte. C'est une application du principe de participation et un moyen d'augmenter le taux de présence.

Partie 5 – Construire et suivre le budget

Objectifs – Objectifs de la partie

- Classer des charges et des produits dans les comptes du plan comptable associatif.
- Calculer un coût horaire chargé et le coût du temps affecté au projet.
- Construire un budget prévisionnel équilibré, contributions en nature comprises.
- Calculer et interpréter des ratios d'analyse.
- Calculer des écarts entre le prévu et le réalisé et les expliquer.
- Calculer le coût complet d'un atelier et le nombre minimal de participants.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Plan comptable associatif (règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018) ; formulaire de demande de subvention : Cerfa n° 12156.
- Charges : 60 achats ; 61 services extérieurs (locations, assurances) ; 62 autres services extérieurs (honoraires, publicité et impressions, déplacements) ; 63 impôts et taxes ; 64 charges de personnel ; 86 emplois des contributions volontaires en nature.
- Produits : 70 ventes et participations ; 74 subventions d'exploitation ; 75 cotisations et dons ; 87 contributions volontaires en nature ; l'autofinancement du porteur complète.
- Règles d'or : équilibre (total des charges = total des produits) ; compte 86 = compte 87 ; cofinancement ; cohérence avec les actions ; justification (quantité × coût unitaire) ; prudence (acquis et sollicités).
- Coût horaire chargé = brut mensuel × (1 + taux de charges patronales) / heures mensuelles ; à 35 h par semaine : 35 × 52 / 12 = 151,67 h. On utilise toujours le taux fourni par l'employeur.
- Écart (€) = réalisé − prévu ; écart (%) = écart / prévu × 100. Un écart global inférieur à 5 % est en général jugé satisfaisant ; chaque écart important est expliqué.

Exercice 8.25 – La structure d'un budget prévisionnel (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution et application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association des familles du Clos-Fleuri (fictive) prépare son premier budget de projet. Le trésorier a listé les lignes, mais ne sait pas où les placer.

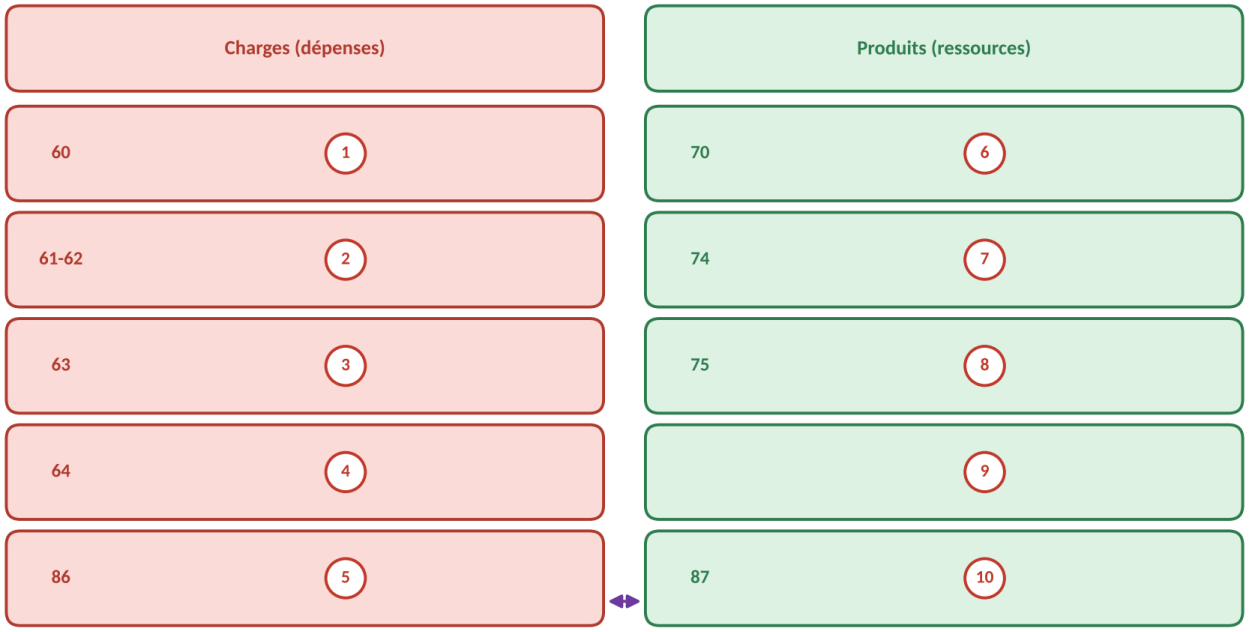


Figure 8.7 – Document 1 – La structure d'un budget prévisionnel associatif (schéma à légender)

Document 2 – Seize lignes à classer

a) Denrées alimentaires des ateliers. b) Petit matériel de cuisine. c) Location d'une salle. d) Assurance de l'activité. e) Impression des affiches. f) Honoraires d'une diététicienne libérale. g) Remboursement des déplacements. h) Salaire brut d'une animatrice. i) Cotisations patronales de cette animatrice. j) Taxe sur les salaires. k) Salle prêtée gratuitement par la mairie (valorisée). l) Heures de bénévolat (valorisées). m) Subvention de la CAF. n) Participation des familles. o) Cotisations des adhérents. p) Don d'un commerçant.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 11 du document 1. (5,5 pts)
2. Classez les seize lignes du document 2 dans les comptes. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi la salle prêtée par la mairie apparaît deux fois dans le budget. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.26 – Calculer un coût horaire chargé (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour le budget du projet de l'association des familles du Clos-Fleuri, la directrice vous communique les salaires et les taux de charges patronales des trois salariées qui y travailleront (données fictives ; le taux réel dépend des allègements de cotisations de chaque structure).

Document 1 – Salaires et temps affecté au projet

Salariée	Salaire brut mensuel	Taux de charges patronales	Temps de travail	Heures sur le projet
Animatrice	1 950 €	40 %	35 h par semaine	48 h
Coordinatrice	2 600 €	44 %	35 h par semaine	20 h
Agent d'entretien	1 150 €	38 %	24 h par semaine	10 h

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre d'heures mensuelles d'un temps plein et du temps partiel de 24 heures. (2 pts)

2. Calculez le coût employeur mensuel et le coût horaire chargé de chaque salariée (au centime). (4,5 pts)

3. Calculez le coût du temps de chaque salariée sur le projet et le total à inscrire au compte 64. (2,5 pts)

4. Expliquez pourquoi on ne peut pas inscrire le salaire brut seul. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.27 – Construire un budget équilibré (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association des familles du Clos-Fleuri prépare six ateliers de 3 heures pour 12 familles. Vous construisez le budget prévisionnel à partir des éléments réunis par la directrice.

Document 1 – Éléments du budget (fictifs)

- Denrées : 32 € par atelier. Petit matériel : 180 €. Impression des fiches et des affiches : 95 €.
- Diététicienne libérale : 2 h 30 par atelier, honoraires de 55 € de l'heure.
- Animatrice : 48 h à 18,00 € de l'heure. Coordinatrice : 20 h à 24,69 € de l'heure.
- Salle prêtée par la mairie : 3 h par atelier, valorisée à 25 € de l'heure.
- Bénévolat : 3 bénévoles par atelier, 3 h chacun, valorisées à 12 € de l'heure (taux fixé par l'association).
- CAF : 1 500 € (acquis). Commune : 800 € (sollicités). Participation des familles : 1,50 € par famille et par atelier.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez chaque ligne de charges et le total des charges. (4 pts)

2. Calculez les contributions en nature et la participation des familles. (2 pts)

3. Calculez l'autofinancement nécessaire pour équilibrer le budget. (2 pts)

4. Présentez le budget sous forme de tableau équilibré. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.28 – Analyser un budget avec des ratios (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le comité de pilotage du projet du Clos-Fleuri veut comprendre le budget construit à l'exercice 8.27 (total : 3 747,80 €, dont 1 098 € de contributions en nature ; personnel : 1 357,80 € ; CAF : 1 500 € ; commune : 800 € ; participation des familles : 108 € ; autofinancement : 241,80 €). Vous préparez des ratios.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de la subvention de la CAF et la part des financements publics dans le budget total. (2 pts)
2. Calculez la part des charges de personnel et la part des contributions en nature. (2 pts)
3. Calculez le coût par famille et le coût par heure d'atelier. (2 pts)
4. Calculez la part de l'autofinancement dans les charges monétaires. (2 pts)
5. Calculez ce que paie une famille pour le cycle, et ce que cela représente du coût par famille. (2 pts)
6. Rédigez l'interprétation de ces ratios pour le comité (5 à 6 lignes). (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.29 – Analyser les écarts entre le prévu et le réalisé (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le cycle d'ateliers du Clos-Fleuri est terminé. Vous préparez le compte rendu financier pour la CAF et la commune.

Document 1 – Budget prévu et réalisé

Poste	Prévu	Réalisé
Denrées	192,00 €	231,60 €
Petit matériel	180,00 €	154,90 €
Impression	95,00 €	95,00 €
Diététicienne	825,00 €	825,00 €
Animatrice	864,00 €	972,00 €
Coordinatrice	493,80 €	493,80 €
Salle prêtée (contribution en nature)	450,00 €	375,00 €
Bénévolat (contribution en nature)	648,00 €	756,00 €

Document 2 – Notes de la directrice

« Les prix des fruits ont beaucoup augmenté au printemps. On a trouvé une batterie de casseroles en promotion. L'animatrice a fait six heures de plus, pour rappeler les familles absentes et accompagner deux mères au marché. Le dernier atelier a eu lieu dans la cuisine de l'école, prêtée sans frais et non valorisée. Trois mères sont devenues bénévoles et ont aidé à la fin du cycle. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'écart en euros et en pourcentage pour chaque poste, puis pour le total. (5 pts)
2. Expliquez chaque écart à l'aide du document 2. (3 pts)
3. Calculez l'écart qui touche réellement la trésorerie de l'association (hors contributions en nature) et dites comment il est couvert. (2 pts)
4. Le résultat global est-il satisfaisant ? Justifiez. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.30 – Calculer le coût complet d'un atelier et le seuil de participants (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service prévention d'une caisse de retraite (fictive) finance des ateliers « cuisine et convivialité » pour des retraités vivant à domicile. Elle verse à l'association organisatrice un forfait de 20 € par personne présente. Chaque participant paie 3 €. La présidente de l'association vous demande à partir de combien de participants l'atelier couvre ses coûts.

Document 1 – Coûts d'un atelier (fictifs)

- Animatrice : 3 h 30 (préparation, animation, rangement) à 18,00 € de l'heure.
- Diététicienne libérale : 2 h 30 à 55 € de l'heure.
- Location de la salle : 30 € par atelier.
- Denrées : 2,40 € par participant. Fiche recette imprimée : 0,35 € par participant.
- La salle accueille 14 personnes au plus.

À vous de jouer – Questions

1. Distinguez les coûts fixes et les coûts variables, et calculez-les. (3 pts)
2. Calculez le coût par participant pour 6, 8, 10, 12 et 14 participants. Présentez un tableau. (4 pts)
3. Calculez le nombre minimal de participants pour que l'atelier couvre ses coûts. (3 pts)
4. Les ateliers réunissent en moyenne 9 personnes. Calculez la perte par atelier et proposez deux solutions. (4 pts)
5. Expliquez pourquoi il ne faut pas augmenter fortement la participation demandée aux retraités. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 8.25

1. Légendes : 1 Achats (60) ; 2 Services extérieurs (61-62) ; 3 Impôts et taxes (63) ; 4 Charges de personnel (64) ; 5 Emplois des contributions volontaires en nature (86) ; 6 Ventes, participation des usagers (70) ; 7 Subventions d'exploitation (74) ; 8 Cotisations, dons (75) ; 9 Autofinancement du porteur ; 10 Contributions volontaires en nature (87) ; 11 Total des charges = total des produits ; compte 86 = compte 87.

2. 60 : a), b). 61 : c), d). 62 : e), f), g). 63 : j). 64 : h), i). 86 et 87 : k), l). 74 : m). 70 : n). 75 : o), p).

3. La salle ne coûte rien à l'association, mais elle a une valeur. On l'inscrit en **charge** au compte 86 (on l'utilise) et en **produit** au compte 87 (on la reçoit), pour le même montant. Le budget reste équilibré, et il montre la contribution réelle de la mairie et le vrai coût du projet.

Corrigé – Exercice 8.26

1. Temps plein : 35 × 52 / 12 = **151,67 h** par mois. Temps partiel : 24 × 52 / 12 = **104 h** par mois.

2. Animatrice : 1 950 × 1,40 = **2 730,00 €** ; 2 730 / 151,67 = **18,00 €** de l'heure. Coordinatrice : 2 600 × 1,44 = **3 744,00 €** ; 3 744 / 151,67 = **24,69 €** de l'heure. Agent d'entretien : 1 150 × 1,38 = **1 587,00 €** ; 1 587 / 104 = **15,26 €** de l'heure.

3. Animatrice : 48 × 18,00 = **864,00 €** ; coordinatrice : 20 × 24,69 = **493,80 €** ; agent : 10 × 15,26 = **152,60 €**. Total au compte 64 : 864,00 + 493,80 + 152,60 = **1 510,40 €**.

4. L'employeur paie aussi les cotisations patronales : le coût réel d'une heure est bien supérieur au salaire brut. Inscrire le brut seul sous-estimerait les charges et déséquilibrerait le budget réalisé.

Corrigé – Exercice 8.27

1. Denrées : 6 × 32 = **192,00 €** ; petit matériel : **180,00 €** ; impression : **95,00 €** ; diététicienne : 6 × 2,5 × 55 = **825,00 €** ; animatrice : 48 × 18,00 = **864,00 €** ; coordinatrice : 20 × 24,69 = **493,80 €** ; salle : 6 × 3 × 25 = **450,00 €** ; bénévolat : 3 × 6 × 3 × 12 = **648,00 €**. Total des charges : **3 747,80 €**.

2. Contributions en nature : 450 + 648 = **1 098,00 €**. Participation : 12 × 6 × 1,50 = **108,00 €**.

3. Autofinancement : 3 747,80 − 1 500 − 800 − 108 − 1 098 = **241,80 €**.

4. Budget prévisionnel :

Charges	Montant	Produits	Montant
60 – Denrées	192,00 €	70 – Participation des familles	108,00 €
60 – Petit matériel	180,00 €	74 – CAF (acquis)	1 500,00 €
62 – Impression	95,00 €	74 – Commune (sollicité)	800,00 €
62 – Honoraires de la diététicienne	825,00 €	Autofinancement	241,80 €
64 – Animatrice	864,00 €	87 – Mise à disposition de la salle	450,00 €
64 – Coordinatrice	493,80 €	87 – Bénévolat	648,00 €
86 – Mise à disposition de la salle	450,00 €		
86 – Bénévolat	648,00 €		
Total	**3 747,80 €**	**Total**	**3 747,80 €**

Corrigé – Exercice 8.28

1. CAF : 1 500 / 3 747,80 × 100 = **40,0 %**. Financements publics (CAF et commune) : 2 300 / 3 747,80 × 100 = **61,4 %**.

2. Personnel : 1 357,80 / 3 747,80 × 100 = **36,2 %**. Contributions en nature : 1 098 / 3 747,80 × 100 = **29,3 %**.

3. Coût par famille : 3 747,80 / 12 = **312,32 €**. Coût par heure d'atelier : 3 747,80 / (6 × 3) = 3 747,80 / 18 = **208,21 €**.

4. Charges monétaires : 3 747,80 − 1 098 = 2 649,80 € ; autofinancement : 241,80 / 2 649,80 × 100 = **9,1 %**.

5. Une famille paie 6 × 1,50 = **9 €** pour le cycle, soit 9 / 312,32 × 100 = **2,9 %** du coût par famille.

6. Exemple : « Le projet est financé aux six dixièmes par des fonds publics, dont 40 % par la CAF. Près de 30 % de sa valeur vient de contributions en nature (salle, bénévolat), ce qui montre l'engagement du territoire. Le personnel représente un peu plus d'un tiers du budget, et les honoraires de la diététicienne s'y ajoutent. La participation des familles est symbolique (9 € pour le cycle, moins de 3 % du coût) : elle favorise l'engagement sans exclure. L'autofinancement reste modeste (9,1 % des charges monétaires). »

Corrigé – Exercice 8.29

1. Écarts :

Poste	Prévu	Réalisé	Écart (€)	Écart (%)
Denrées	192,00	231,60	+ 39,60	+ 20,6 %
Petit matériel	180,00	154,90	− 25,10	− 13,9 %
Impression	95,00	95,00	0,00	0,0 %
Diététicienne	825,00	825,00	0,00	0,0 %
Animatrice	864,00	972,00	+ 108,00	+ 12,5 %
Coordinatrice	493,80	493,80	0,00	0,0 %
Salle (nature)	450,00	375,00	− 75,00	− 16,7 %
Bénévolat (nature)	648,00	756,00	+ 108,00	+ 16,7 %
Total	**3 747,80**	**3 903,30**	**+ 155,50**	**+ 4,1 %**

2. Denrées : hausse du prix des fruits au printemps. Petit matériel : achat en promotion. Animatrice : 6 heures de plus (6 × 18 = 108 €) pour rappeler les familles absentes et accompagner deux mères au marché. Salle : un atelier sur six a eu lieu dans la cuisine de l'école, non valorisée (5 × 3 × 25 = 375 €). Bénévolat : 9 heures de plus (108 / 12 = 9 h), grâce aux trois mères devenues bénévoles, ce qui est un signe positif de participation.

3. Écart de trésorerie (hors comptes 86 et 87) : 39,60 − 25,10 + 108,00 = **+ 122,50 €**. Il est couvert par l'autofinancement de l'association, qui passe de 241,80 € à 241,80 + 122,50 = **364,30 €**. Les contributions en nature changent aussi de montant, mais les comptes 86 et 87 restent égaux (375 + 756 = 1 131 €).

4. Oui : l'écart global est de + 4,1 %, inférieur au repère de 5 %. Chaque écart est expliqué ; les dépenses supplémentaires de personnel ont servi la participation (rappels, accompagnement au marché). Il faudra prévoir une marge sur les denrées et du temps pour les rappels dans le prochain budget.

Corrigé – Exercice 8.30

1. Coûts fixes (ne dépendent pas du nombre de participants) : animatrice 3,5 × 18 = 63,00 € ; diététicienne 2,5 × 55 = 137,50 € ; salle 30,00 € ; total **230,50 €** par atelier. Coûts variables (par participant) : denrées 2,40 € + fiche 0,35 € = **2,75 €**.

2. Coût par participant = 230,50 / n + 2,75 :

Participants	Coût total de l'atelier	Coût par participant	Recettes (23 € × n)	Résultat de l'atelier
6	247,00 €	41,17 €	138,00 €	− 109,00 €
8	252,50 €	31,56 €	184,00 €	− 68,50 €
10	258,00 €	25,80 €	230,00 €	− 28,00 €
12	263,50 €	21,96 €	276,00 €	+ 12,50 €

Participants	Coût total de l'atelier	Coût par participant	Recettes (23 € × n)	Résultat de l'atelier
14	269,00 €	19,21 €	322,00 €	+ 53,00 €

3. Recette par participant : 20 + 3 = 23 € ; chaque participant rapporte 23 − 2,75 = 20,25 € pour couvrir les coûts fixes. Seuil : 230,50 / 20,25 = **11,4**, soit **12 participants** au minimum.

4. Avec 9 participants : coût 230,50 + 9 × 2,75 = 255,25 € ; recettes 9 × 23 = 207,00 € ; perte **48,25 €** par atelier. Solutions : réduire les coûts fixes (la diététicienne intervient un atelier sur deux et l'animatrice formée assure les autres ; salle prêtée gratuitement par la commune) ; augmenter la fréquentation (inscription par les relais, covoiturage, rappels) ; demander un complément à un autre financeur (conférence des financeurs).

5. Une forte participation financière exclurait les retraités aux petites pensions, qui sont souvent les plus isolés et les plus exposés à la dénutrition. Cela irait contre l'objectif d'équité du projet (universalisme proportionné).

Partie 6 – La trésorerie, la logistique et les méthodes pédagogiques

Objectifs – Objectifs de la partie

- Calculer un plan de trésorerie mois par mois et repérer le besoin de trésorerie.
- Proposer des solutions à un problème de trésorerie.
- Calculer des quantités brutes à partir d'une recette, d'un nombre de portions et d'un rendement.
- Préparer la logistique d'un atelier : check-list et conducteur.
- Choisir une méthode pédagogique adaptée au type d'objectif.
- Calculer le coût et les apports d'une recette d'atelier avec la table Ciqual 2025.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Un budget équilibré sur l'année peut poser un problème de trésorerie : les dépenses arrivent avant les recettes (une subvention est souvent versée en partie à la notification, le solde après le bilan).
- Solde de fin de mois = solde de début + encaissements − décaissements. Le besoin de trésorerie maximal est le solde le plus négatif. Les contributions en nature n'entrent pas dans la trésorerie.
- Solutions : demander une avance ou un acompte, décaler des achats, échelonner les paiements, mobiliser la trésorerie de la structure, demander le versement anticipé d'un cofinancement.
- Mise à l'échelle : coefficient = portions voulues / portions de la recette. Poids brut = poids net / rendement (partie comestible).
- Méthodes pédagogiques : expositive, interrogative, démonstrative, active, coopérative. La « pyramide de l'apprentissage » (« on retient 10 % de ce qu'on lit… ») ne repose sur aucune étude.

Exercice 8.31 – Le principe du plan de trésorerie (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution et application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le trésorier de l'association Cuisine et Partage du Val (fictive) ne comprend pas pourquoi la banque l'appelle alors que le budget du projet est équilibré. Vous lui expliquez le plan de trésorerie.

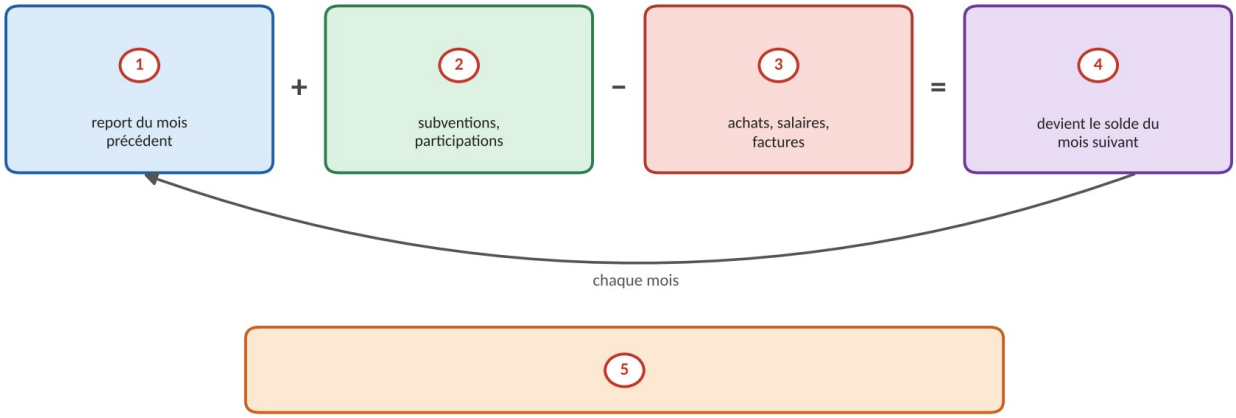


Figure 8.8 – Document 1 – Le calcul d'un plan de trésorerie (schéma à légender)

Document 2 – Les quatre premiers mois du projet

Trésorerie disponible au 1er janvier : 300 €. Janvier : aucun encaissement, 250 € de décaissements. Février : aucun encaissement, 420 € de décaissements. Mars : subvention de 1 200 € encaissée, 380 € de décaissements. Avril : aucun encaissement, 300 € de décaissements.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Calculez le solde de fin de mois de janvier à avril. (4 pts)
3. Indiquez le mois où un problème apparaît et son montant. (1,5 pt)
4. Expliquez au trésorier, en deux phrases, pourquoi un budget équilibré n'empêche pas ce problème. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.32 – Construire un plan de trésorerie sur huit mois (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association Pas à Pas (fictive) accompagne des familles d'enfants à besoins alimentaires particuliers. Son projet d'ateliers dure de janvier à août 2027. Le budget est équilibré, mais la directrice s'inquiète des versements. Vous construisez le plan de trésorerie.

Document 1 – Encaissements et décaissements prévus (hors contributions en nature)

- Trésorerie disponible au 1er janvier : 500 €.
- Commune : 1 000 € versés en mars.
- ARS : subvention de 3 000 €, versée pour moitié à la notification (mai) et pour moitié après le bilan (décembre).
- Participation des familles : 40 € par mois, de mars à août.
- Décaissements : janvier 350 € ; février 420 € ; mars 680 € ; avril 720 € ; mai 640 € ; juin 580 € ; juillet 300 € ; août 210 €.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez le plan de trésorerie de janvier à août : encaissements, décaissements, calcul et solde de fin de mois. (5 pts)

2. Indiquez les mois de solde négatif et le besoin de trésorerie maximal. (2 pts)

3. Calculez le solde après le versement du solde de l'ARS en décembre, et vérifiez-le avec les totaux. (2 pts)

4. Proposez trois solutions adaptées à cette situation. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.33 – Calculer les quantités à acheter (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un foyer d'hébergement pour adultes en insertion (structure fictive) organise trois ateliers où l'on prépare le même plat : un dahl de lentilles corail aux carottes, servi avec du riz. Chaque atelier sert 15 portions. La recette de base est prévue pour 4 personnes.

Document 1 – Recette pour 4 personnes (poids nets) et prix (fictifs)

Denrée	Poids net pour 4	Rendement	Prix
Lentilles corail sèches	200 g	100 %	2,90 € le kg
Carottes épluchées	300 g	85 %	1,40 € le kg
Oignons épluchés	100 g	90 %	1,80 € le kg
Lait de coco	200 g	100 %	4,50 € le kg
Riz blanc cru	240 g	100 %	1,90 € le kg
Coriandre, épices, sel	–	–	0,90 € par atelier

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coefficient de mise à l'échelle. (1 pt)
2. Calculez, pour un atelier, le poids net et le poids brut de chaque denrée. (4 pts)
3. Calculez les quantités brutes à commander pour les trois ateliers. (2 pts)
4. Calculez le coût d'un atelier, le coût par portion et le coût des trois ateliers (coût de chaque ligne arrondi au centime). (3 pts)
5. Calculez le poids de carottes épluchées obtenu si l'on oublie le rendement, et dites ce qui se passe. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.34 – Préparer la logistique d'un atelier (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez le premier atelier du foyer d'hébergement de l'exercice 8.33, le jeudi de 10 h à 13 h, dans la cuisine collective du foyer (deux plaques, un four, un seul évier). Douze résidents sont inscrits, dont un allergique à l'arachide et une personne en fauteuil roulant. L'atelier se termine par le repas pris ensemble.

Document 1 – Ce qu'a prévu l'éducateur du foyer

« On commence à 10 h, tout le monde arrive en même temps. Je fais les courses le matin même. On épluche tous les légumes ensemble à l'évier. On mange à 13 h, et on range après. »

À vous de jouer – Questions

1. Repérez quatre risques dans l'organisation prévue par l'éducateur. (2 pts)
2. Construisez la check-list « avant, jour J, après » de l'atelier. (4 pts)
3. Construisez le conducteur de l'atelier, de 9 h 30 à 13 h 30, en indiquant pour chaque séquence l'horaire, l'activité et le rôle de l'animatrice. (4 pts)
4. Indiquez les adaptations prévues pour la personne en fauteuil roulant et pour la personne allergique. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.35 – Choisir une méthode pédagogique (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une collègue prépare des séances pour un groupe de jeunes de 16 à 25 ans accompagnés par une association d'insertion (fictive). Elle a écrit un objectif par séance, et cite dans son projet une affirmation entendue en formation.

Document 1 – Cinq objectifs de séance

a) À la fin de la séance, les jeunes savent citer trois repères du PNNS sur les fruits et légumes.

b) À la fin de la séance, les jeunes savent cuire des pâtes et des œufs durs sans aide.

c) À la fin de la séance, les jeunes savent comparer le prix au kilo de deux produits en rayon.

d) À la fin de la séance, les jeunes osent goûter un légume qu'ils ne connaissent pas.

e) À la fin de la séance, les jeunes savent repérer une technique publicitaire dans une publicité pour une boisson sucrée.

Document 2 – L'affirmation citée par la collègue

« On retient 10 % de ce qu'on lit, 20 % de ce qu'on entend, 30 % de ce qu'on voit, et 90 % de ce qu'on fait. »

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque objectif : connaissance, savoir-faire ou attitude. (2,5 pts)
2. Proposez pour chaque objectif une méthode pédagogique et un outil. (5 pts)
3. Que pensez-vous de l'affirmation du document 2 ? Proposez une autre justification des méthodes actives. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.36 – Coût et apports d'une recette d'atelier (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 45 min*

Mise en situation – Mise en situation

La crèche parentale Les Petits Cailloux (structure fictive) propose aux parents un atelier « déjeuner du soir vite fait » : un gratin de pâtes complètes au brocoli et au thon, puis une poire. L'atelier prépare 10 portions pour adultes. Le budget de l'atelier est de 2,50 € par portion.

Document 1 – Grammages nets par portion, pertes et prix (fictifs)

Denrée	Grammage net	Perte	Prix
Pâtes sèches au blé complet, crues	70 g	sans perte	2,20 € le kg
Brocoli	120 g	30 %	3,20 € le kg
Thon au naturel, égoutté	50 g	sans perte	14,00 € le kg égoutté
Lait demi-écrémé	120 g	sans perte	1,05 € le kg
Farine de blé T65	8 g	sans perte	1,10 € le kg
Huile de colza	5 g	sans perte	3,20 € le kg
Emmental râpé	15 g	sans perte	9,90 € le kg
Poire	120 g	10 %	2,60 € le kg
Épices, muscade, sel	–	–	forfait 0,60 € pour 10 portions

Document 2 – Extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Pâtes sèches, au blé complet, crues (9870)	353	11,8	67,6	1,8	2,2	6,1	0,016	32,1	3,2	0
Brocoli, cru (20057)	31,9	2,9	2,15	1,7	0,36	2,6	0,075	47,5	0,81	91,2
Thon, au naturel, appertisé, égoutté (26039)	143	26,8	0	0	3,94	0	0,74	6,26	0,76	traces
Lait demi-écrémé, pasteurisé (19042)	46,4	3,19	4,9	4,81	1,54	0	0,078	119	0,041	1,6
Farine de blé tendre ou froment T65 (9435)	346	10	71,5	1,5	1	3,5	0,03	25,3	1,31	–
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0,023	0
Emmental ou emmenthal (12115)	373	27,9	traces	traces	28,8	0	0,61	978	0,15	traces
Poire, chair et peau, crue (13037)	56,6	0,36	12,3	9,75	0,27	2,9	0,0045	6,46	0,072	4,3

On calcule avec les poids nets (le brocoli et les pâtes sont pesés crus) ; « traces », « < » et « – » sont comptés

0.

À vous de jouer – Questions

1. Établissez le bon de commande pour 10 portions (poids net total, poids brut, coût de chaque ligne au centime) et vérifiez le budget. (5 pts)
2. Calculez les apports d'une portion du repas complet (gratin et poire) en énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer et vitamine C. (5 pts)
3. Calculez la répartition de l'énergie entre protéines, lipides et glucides. (2 pts)
4. Commentez l'intérêt nutritionnel de ce repas pour un adulte (fibres, calcium, vitamine C, sel). (2 pts)
5. Proposez une version sans poisson pour une famille végétarienne, et dites ce qui change. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 8.31

1. Légendes : 1 Solde de début de mois ; 2 Encaissements ; 3 Décaissements ; 4 Solde de fin de mois ; 5 Solde négatif = besoin de trésorerie : avance, acompte, décalage des achats.

2. Janvier : 300 + 0 − 250 = **50 €**. Février : 50 + 0 − 420 = **− 370 €**. Mars : − 370 + 1 200 − 380 = **450 €**. Avril : 450 + 0 − 300 = **150 €**.

3. En **février** : le solde est de **− 370 €**. L'association ne peut pas payer ses dépenses sans découvert bancaire.

4. Le budget compare les charges et les produits sur toute la durée du projet, sans tenir compte des dates. La trésorerie suit les dates réelles des entrées et des sorties d'argent : si la subvention arrive en mars et que les dépenses commencent en janvier, il manque de l'argent entre-temps.

Corrigé – Exercice 8.32

1. Plan de trésorerie :

Mois	Encaissements	Décaissements	Calcul	Solde de fin de mois
Janvier	0	350	500 + 0 − 350	150
Février	0	420	150 − 420	− 270
Mars	1 040	680	− 270 + 1 040 − 680	90
Avril	40	720	90 + 40 − 720	− 590
Mai	1 540	640	− 590 + 1 540 − 640	310
Juin	40	580	310 + 40 − 580	− 230
Juillet	40	300	− 230 + 40 − 300	− 490
Août	40	210	− 490 + 40 − 210	− 660

Mars : 1 000 (commune) + 40 (familles) = 1 040 € ; mai : 1 500 (ARS, première moitié) + 40 = 1 540 €.

2. Soldes négatifs en février, avril, juin, juillet et août. Besoin de trésorerie maximal : **660 €**, fin août, et il dure jusqu'en décembre.

3. Décembre : − 660 + 1 500 = **840 €**. Vérification : encaissements de janvier à août = 1 040 + 40 + 1 540 + 4 × 40 = **2 740 €** ; décaissements = 350 + 420 + 680 + 720 + 640 + 580 + 300 + 210 = **3 900 €** ; 500 + 2 740 − 3 900 + 1 500 = **840 €**.

4. Exemples : demander à l'ARS un acompte plus important (par exemple 80 % à la notification) ; demander à la commune un versement en janvier plutôt qu'en mars ; décaler en septembre les achats qui peuvent attendre et échelonner les paiements des intervenants ; mobiliser la trésorerie générale de l'association ou un prêt court, après accord du bureau.

Corrigé – Exercice 8.33

1. Coefficient : 15 / 4 = **3,75**.

2. et 3. Quantités :

Denrée	Poids net pour 15	Poids brut pour 15	Brut pour 3 ateliers
Lentilles corail	200 × 3,75 = 750 g	750 g	2,25 kg
Carottes	300 × 3,75 = 1 125 g	1 125 / 0,85 = 1 323,5 g	3,97 kg
Oignons	100 × 3,75 = 375 g	375 / 0,90 = 416,7 g	1,25 kg
Lait de coco	200 × 3,75 = 750 g	750 g	2,25 kg
Riz blanc cru	240 × 3,75 = 900 g	900 g	2,70 kg

4. Coût d'un atelier : lentilles 0,750 × 2,90 = 2,18 € ; carottes 1,3235 × 1,40 = 1,85 € ; oignons 0,4167 × 1,80 = 0,75 € ; lait de coco 0,750 × 4,50 = 3,38 € ; riz 0,900 × 1,90 = 1,71 € ; forfait 0,90 €. Total : **10,77 €** par atelier ; **0,72 € par portion** ; **32,31 €** pour les trois ateliers.

5. Si l'on achète 1 125 g de carottes brutes, on obtient 1 125 × 0,85 = **956 g** épluchés, soit 169 g de moins que prévu : les portions seront plus petites ou il faudra racheter en urgence. À l'inverse, surestimer conduit au gaspillage.

Corrigé – Exercice 8.34

1. Risques : faire les courses le matin même (oubli, retard, produit manquant) ; accueillir tout le monde à 10 h sans installation préalable ; un seul évier pour 12 personnes (attente, désordre) ; pas de recueil des allergies ni de vérification de l'étiquetage (arachide) ; pas d'adaptation pour la personne en fauteuil ; manger à 13 h sans avoir prévu le temps de cuisson du riz et du dahl.

2. Check-list :

Moment	Tâches
Avant (J – 7 à J – 1)	Liste de courses chiffrée (exercice 8.33) ; courses la veille ; vérification du matériel (balances, couteaux, planches, casseroles, plaques, four) ; recueil des allergies et lecture des étiquettes (lait de coco, épices : traces d'arachide ?) ; fiches recettes illustrées ; rappel aux inscrits la veille ; poste de travail adapté pour le fauteuil
Jour J	Installation à 9 h 30 ; lavage des mains ; affichage de la recette et des allergènes ; émargement ; trois postes de travail (légumes, dahl, riz) ; respect de la marche en avant ; repas ensemble
Après	Rangement et vaisselle en équipes ; restes refroidis rapidement et étiquetés, ou jetés ; inventaire du matériel et des denrées ; bilan à chaud ; saisie des présences et des avis

3. Conducteur (exemple) :

Horaire	Activité	Rôle de l'animatrice
9 h 30 – 10 h	Installation des postes, denrées pesées par poste	Prépare avec l'éducateur
10 h – 10 h 15	Accueil, lavage des mains, présentation de la recette avec photos	Accueille, explique
10 h 15 – 10 h 45	Épluchage et découpe en trois postes, à tour de rôle à l'évier	Montre les gestes, veille à la sécurité
10 h 45 – 11 h 30	Cuisson du dahl ; cuisson du riz ; dressage de la table	Fait goûter, ajuste l'assaisonnement
11 h 30 – 12 h	Calcul du coût par portion avec les participants ; échange	Anime l'échange
12 h – 13 h	Repas partagé	Mange avec le groupe, recueille les avis
13 h – 13 h 30	Rangement en équipes, bilan à chaud	Organise, remercie

4. Fauteuil roulant : un plan de travail à hauteur adaptée (table basse ou planche sur les genoux), une circulation dégagée, une tâche qu'il peut faire assis (découpe, assaisonnement, calcul du coût). Allergie à l'arachide : vérification de toutes les étiquettes (mention « traces »), plan de travail et ustensiles nettoyés, pas de produit à risque dans l'atelier, connaissance du protocole d'urgence et du traitement de la personne.

Corrigé – Exercice 8.35

1. a) connaissance ; b) savoir-faire ; c) savoir-faire ; d) attitude ; e) savoir-faire critique, qui touche aussi une

attitude (esprit critique).

2. Exemples : a) méthode interrogative et ludique : quiz avec cartes et photos d'aliments ; b) méthode démonstrative puis active : démonstration, puis chaque jeune cuisine à son poste ; c) méthode active sur le terrain : comparaison en magasin avec une calculatrice et une fiche de relevé ; d) méthode active et coopérative : dégustation à l'aveugle sans obligation, dans un climat bienveillant, avec un jeune pair qui goûte en premier ; e) méthode interrogative et active : analyse en petits groupes de trois publicités réelles, puis débat.

3. Ces pourcentages, attribués à tort à Edgar Dale, ne reposent sur **aucune étude** : il ne faut pas les citer comme une preuve. On justifie plutôt les méthodes actives par ce qui est établi : l'engagement actif, la pratique répétée et le retour d'information favorisent l'apprentissage, surtout pour les savoir-faire.

Corrigé – Exercice 8.36

1. Bon de commande pour 10 portions :

Denrée	Poids net total	Poids brut	Coût
Pâtes complètes	700 g	700 g	0,700 × 2,20 = 1,54 €
Brocoli	1 200 g	1 200 / 0,70 = 1 714 g	1,714 × 3,20 = 5,49 €
Thon égoutté	500 g	500 g	0,500 × 14,00 = 7,00 €
Lait demi-écrémé	1 200 g	1 200 g	1,200 × 1,05 = 1,26 €
Farine	80 g	80 g	0,080 × 1,10 = 0,09 €
Huile de colza	50 g	50 g	0,050 × 3,20 = 0,16 €
Emmental râpé	150 g	150 g	0,150 × 9,90 = 1,49 €
Poires	1 200 g	1 200 / 0,90 = 1 333 g	1,333 × 2,60 = 3,47 €
Épices, sel	–	–	0,60 €
Total			**21,10 €**

Coût par portion : 21,10 / 10 = **2,11 €**, inférieur au budget de 2,50 € (marge de 0,39 € par portion). Le thon représente 7,00 / 21,10 = 33,2 % du coût.

2. Apports d'une portion (gratin + poire) : énergie **609,1 kcal** ; protéines **34,39 g** ; glucides **76,26 g**, dont sucres **20,89 g** ; lipides **15,51 g** ; fibres **11,15 g** ; sel **0,66 g** ; calcium **381,9 mg** ; fer **3,86 mg** ; vitamine C **116,5 mg**. Exemple de calcul : protéines des pâtes = 70 × 11,8 / 100 = 8,26 g ; calcium de l'emmental = 15 × 978 / 100 = 146,7 mg.

3. Protéines : 34,39 × 4 / 609,1 × 100 = **22,6 %** ; lipides : 15,51 × 9 / 609,1 × 100 = **22,9 %** ; glucides : 76,26 × 4 / 609,1 × 100 = **50,1 %**. Le reste (environ 3,7 %) vient des fibres (11,15 × 2 = 22,3 kcal).

4. Le repas apporte **37 %** des 30 g de fibres conseillés par jour (11,15 / 30) grâce aux pâtes complètes, au brocoli et à la poire ; **40 %** de la référence de 950 mg de calcium (381,9 / 950), grâce au lait et à l'emmental ; plus que la référence quotidienne de 110 mg de vitamine C (brocoli cru ; une partie sera perdue à la cuisson). Le sel reste modéré (0,66 g). Les lipides sont plutôt bas : on peut garder l'huile de colza, riche en oméga 3.

5. Remplacer le thon par 50 g de pois chiches appertisés égouttés et 1 œuf, ou par du fromage de chèvre. Les protéines baissent un peu (les pois chiches en apportent moins que le thon), les fibres augmentent, le coût diminue. On vérifie avec la table Ciqual avant de valider.

Partie 7 – Piloter : tableau de bord, risques et communication

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire la boucle du pilotage et lire un tableau de bord.
- Construire une matrice des risques et proposer des mesures de prévention.
- Analyser un tableau de bord à mi-parcours et proposer des décisions.
- Construire un plan de communication par cible.
- Mesurer l'efficacité des canaux de communication.
- Réagir à un imprévu (baisse de financement, retrait d'un partenaire) en ajustant le budget.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Pilotage : suivre l'avancement (activités, délais, budget, participation), repérer les écarts et les risques, décider des ajustements, rendre compte aux partenaires et aux financeurs.
- Tableau de bord : quelques indicateurs de suivi, chacun avec une valeur prévue, une valeur réalisée et une analyse. Taux de présence = présences constatées / présences possibles × 100.
- Matrice des risques : criticité = probabilité × gravité (de 1 à 16) ; on traite d'abord les risques les plus critiques, et toujours ceux de gravité maximale.
- Plan de communication : objectifs de communication, cibles, messages, canaux et supports, calendrier, budget et évaluation. Auprès des publics éloignés, les relais humains sont souvent les canaux les plus efficaces.
- Coût par contact = coût du canal / nombre de contacts obtenus ; taux de transformation = inscrits / contacts × 100.

Exercice 8.37 – La boucle du pilotage (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution et application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le jardin partagé des Prés-Verts (association fictive) conduit huit ateliers « du jardin à l'assiette ». À mi-parcours, le comité technique prépare son tableau de bord.

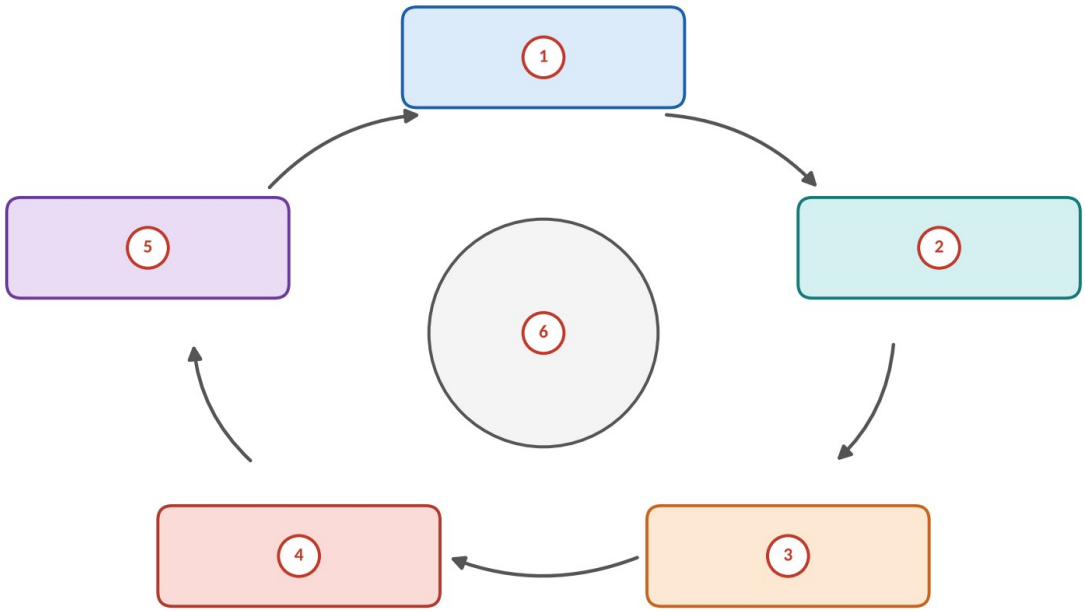


Figure 8.9 – Document 1 – La boucle du pilotage (schéma à légender)

Document 2 – Données à mi-parcours

Indicateur de suivi	Prévu à mi-parcours	Réalisé
Ateliers réalisés	4 sur 8	4
Taux de présence	75 % au moins	38 présences sur 48 possibles
Budget consommé	environ 50 % de 3 000 €	1 260 €
Fiches recettes testées et validées	6 sur 8	5

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Calculez le taux de présence, la part du budget consommée et la part des fiches validées. (3 pts)

3. Complétez la colonne « analyse » du tableau de bord pour chaque indicateur. (2 pts)

4. Proposez une décision pour l'indicateur en retard. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.38 – Construire une matrice des risques (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association Bocal et Compagnie (exercice 8.21) va faire circuler une cuisine mobile, installée dans un camion aménagé, dans six villages. L'équipe a listé les risques et les a notés de 1 (faible) à 4 (fort).

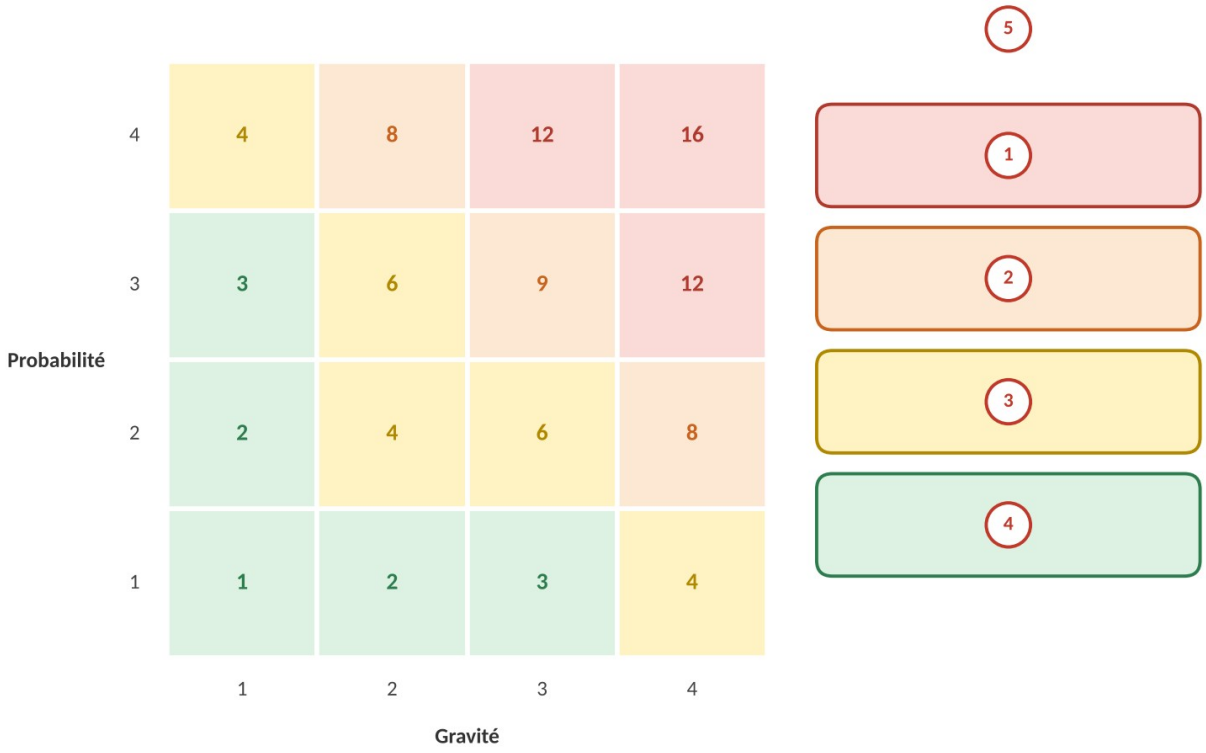


Figure 8.10 – Document 1 – La matrice des risques (schéma à légender)

Document 2 – Les risques identifiés

Risque	Probabilité	Gravité
R1 – Panne du camion un jour d'atelier	2	4
R2 – Mauvais temps qui réduit la fréquentation	3	2
R3 – Faible participation dans certains villages	3	3
R4 – Rupture de la chaîne du froid pendant une tournée	2	4
R5 – Départ d'un bénévole formé	3	2
R6 – Réaction allergique pendant une dégustation	1	4
R7 – Hausse du prix des denrées	4	2

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)

2. Calculez la criticité de chaque risque et classez-les. (3 pts)

3. Proposez une mesure de prévention ou de réduction pour chaque risque. (5 pts)

4. Expliquez pourquoi R6 doit être traité alors que sa criticité est la plus faible. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.39 – Analyser un tableau de bord multisite (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le bailleur social Habitat du Causse (exercice 8.8) a étendu le projet « Cuisiner dans un petit logement » à trois résidences, avec huit ateliers prévus dans chacune. À mi-parcours, vous préparez le tableau de bord pour le comité de pilotage. Budget total : 4 800 €.

Document 1 – Données de suivi à mi-parcours (fictives)

Résidence	Ateliers réalisés	Places par atelier	Présences constatées
A – Les Genêts	4	12	41
B – Le Vallon	4	12	26
C – Les Aubépines	4	9	33

Budget consommé : 2 150 €. Questionnaires « avant » recueillis : 30 sur 36 inscrits. Supports en FALC validés : 3 sur 4 prévus.

Remarques de la référente : « À la résidence B, les ateliers ont lieu à 14 h, en même temps que l'aide aux devoirs ; beaucoup de mères ne peuvent pas venir. La cuisine de la résidence C est très petite, mais le groupe est soudé. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de présence de chaque résidence et le taux global. (4 pts)
2. Calculez le budget consommé et la part des questionnaires recueillis. (2 pts)
3. Présentez le tableau de bord avec une analyse par indicateur (objectif de présence : 75 %). (3 pts)
4. Proposez deux décisions à soumettre au comité de pilotage. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.40 – Construire un plan de communication (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le réfrigérateur solidaire du Val-d'Orbe (exercice 8.7) sera installé en avril 2027. La directrice du CCAS vous demande le plan de communication. Elle insiste : « Personne ne doit avoir honte de se servir. »

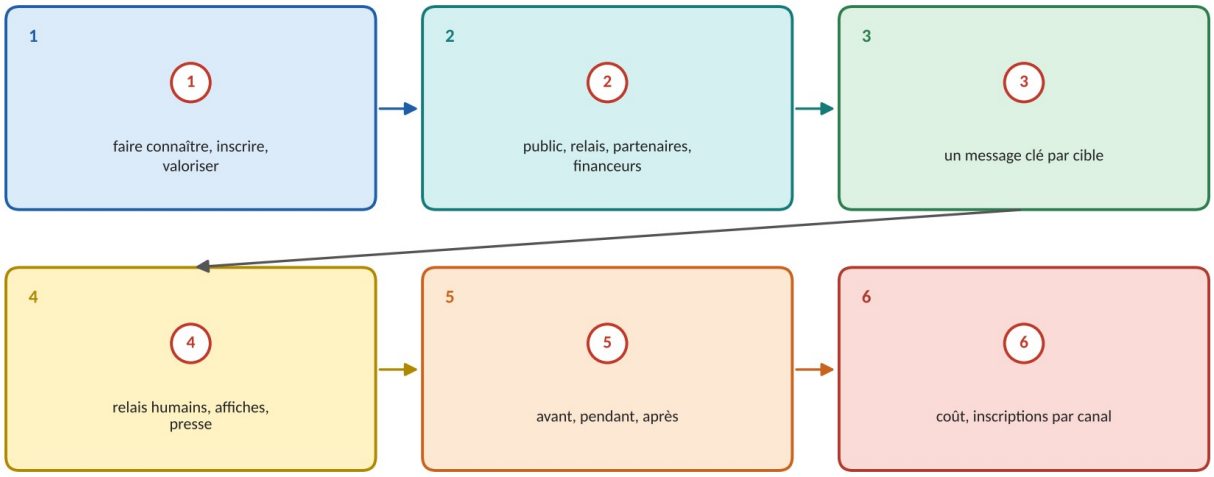


Figure 8.11 – Document 1 – Les six étapes d'un plan de communication (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Formulez trois objectifs de communication distincts des objectifs de santé du projet. (2 pts)
3. Construisez le plan de communication pour quatre cibles : habitants, donateurs (commerces), riverains, élus. Pour chaque cible, donnez l'objectif, le message, le canal et le moment. (5 pts)
4. Proposez deux indicateurs pour évaluer la communication. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.41 – Mesurer l'efficacité des canaux de communication (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle courte · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre social du quartier de la Butte (fictif) a recruté les participants de ses ateliers « bien manger, petit budget » avec six canaux. À la fin des inscriptions, la référente vous transmet les chiffres et vous demande où mettre l'argent l'an prochain.

Document 1 – Contacts, inscriptions et coût par canal (fictifs)

Canal	Personnes qui ont pris contact	Personnes inscrites	Coût du canal
Relais (mères et voisines formées)	17	12	120 € (temps de formation)
Affiches dans le quartier	8	4	35 €
Réseaux sociaux du centre	6	2	72 € (4 h de travail)
Flyers distribués (400)	3	1	60 €
Radio locale (annonce gratuite)	2	1	0 €
Bouche-à-oreille	10	8	0 €

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre total de contacts et d'inscrits, puis la part de chaque canal dans les inscriptions. (3 pts)
2. Calculez le taux de transformation (inscrits / contacts) et le coût par inscrit de chaque canal payant. (3 pts)
3. Calculez la part des inscriptions apportées par les relais humains (relais et bouche-à-oreille) et le rendement des flyers (contacts pour 100 flyers). (2 pts)
4. Rédigez la recommandation pour l'an prochain (5 à 6 lignes). (3 pts)
5. Indiquez une limite de cette analyse. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.42 – Réagir à un imprévu en cours de projet (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 45 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association Saveurs du Faubourg (fictive) conduit huit ateliers culinaires de 15 places. En février, deux mauvaises nouvelles arrivent : la commune réduit sa subvention de 30 %, et l'épicerie partenaire, qui devait donner les denrées, ferme. Vous préparez les propositions pour le comité de pilotage.

Document 1 – Budget prévisionnel initial

Charges	Montant	Produits	Montant
Charges monétaires fixes (coordination, communication, évaluation)	2 000 €	74 – ARS	2 500 €
Charges monétaires des ateliers (400 € par atelier)	3 200 €	74 – Commune	1 000 €
86 – Denrées données par l'épicerie (50 € par atelier)	400 €	74 – CAF	800 €
86 – Salle et bénévolat (forfaits annuels)	500 €	70 – Participation (1,50 € × 15 personnes × 8 ateliers)	180 €
		Autofinancement	720 €
		87 – Contributions en nature	900 €
Total	6 100 €	Total	6 100 €

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la nouvelle subvention de la commune et le nouveau coût monétaire des ateliers si l'association doit acheter les denrées. (2 pts)
2. Calculez le besoin de financement supplémentaire créé par ces deux nouvelles. (2 pts)
3. Le comité envisage de passer à sept ateliers. Calculez les nouvelles charges, la nouvelle participation et l'autofinancement nécessaire. Présentez le budget équilibré. (6 pts)
4. Proposez deux autres solutions et comparez-les à la réduction du nombre d'ateliers. (3 pts)
5. Indiquez qui doit être informé de ces changements et pourquoi l'ARS doit l'être. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 8.37

1. Légendes : 1 Mesurer les indicateurs de suivi ; 2 Comparer le réalisé au prévu ; 3 Analyser les causes des écarts ; 4 Décider des ajustements ; 5 Rendre compte aux partenaires ; 6 Tableau de bord.

2. Présence : 38 / 48 × 100 = **79,2 %**. Budget : 1 260 / 3 000 × 100 = **42,0 %**. Fiches : 5 / 8 × 100 = **62,5 %** (6 prévues à mi-parcours, soit 75 %).

3. Ateliers : conforme (4 sur 8). Présence : conforme (79,2 % ≥ 75 %). Budget : conforme, légèrement sous la moitié ; il reste 1 740 €. Fiches : **en retard** d'une fiche sur le prévu.

4. Exemple : fixer une séance de test de la fiche manquante avec deux jardiniers volontaires avant l'atelier 5, et confier la relecture à une personne désignée, avec une échéance notée au compte rendu.

Corrigé – Exercice 8.38

1. Légendes : 1 Prioritaire : traiter tout de suite ; 2 À traiter : mesures prévues ; 3 À surveiller ; 4 Acceptable ; 5 Criticité = P × G.

2. Criticités : R3 = 3 × 3 = **9** ; R1 = 2 × 4 = **8** ; R4 = 2 × 4 = **8** ; R7 = 4 × 2 = **8** ; R2 = 3 × 2 = **6** ; R5 = 3 × 2 = **6** ; R6 = 1 × 4 = **4**. Classement : R3, puis R1, R4 et R7, puis R2 et R5, puis R6.

3. Exemples : R3 – passer par les mairies, les écoles et des relais dans chaque village, choisir l'horaire avec les habitants, annoncer le passage une semaine avant ; R1 – entretien du camion avant la saison, solution de repli (salle communale avec réchauds), numéro de dépannage ; R4 – glacières et accumulateurs de froid, thermomètre, relevé des températures, produits sensibles achetés le jour même ; R7 – recettes de saison, achats auprès des producteurs partenaires, marge de 10 % sur la ligne denrées ; R2 – tonnelle, solution de repli en salle, report de date ; R5 – former au moins deux bénévoles par poste, conducteurs écrits et partagés ; R6 – recueil des allergies, affichage des 14 allergènes réglementaires (règlement européen INCO n° 1169/2011), variantes sans allergène, protocole d'urgence.

4. R6 a une gravité **maximale** (4) : une réaction allergique peut mettre la vie en danger. Un risque grave appelle toujours des mesures, même s'il est peu probable ; c'est aussi une obligation d'information sur les allergènes.

Corrigé – Exercice 8.39

1. Places possibles : A = 4 × 12 = 48 ; B = 4 × 12 = 48 ; C = 4 × 9 = 36. Taux de présence : A = 41 / 48 × 100 = **85,4 %** ; B = 26 / 48 × 100 = **54,2 %** ; C = 33 / 36 × 100 = **91,7 %**. Global : (41 + 26 + 33) / (48 + 48 + 36) = 100 / 132 × 100 = **75,8 %**.

2. Budget : 2 150 / 4 800 × 100 = **44,8 %** pour 50 % d'avancement ; il reste 2 650 €. Questionnaires : 30 / 36 × 100 = **83,3 %**.

3. Tableau de bord :

Indicateur	Prévu	Réalisé	Analyse
Ateliers réalisés	12 sur 24	12	Conforme
Présence globale	75 %	75,8 %	Conforme, mais masque de grands écarts
Présence résidence B	75 %	54,2 %	Écart de – 20,8 points : horaire en concurrence avec l'aide aux devoirs
Budget consommé	environ 50 %	44,8 %	Conforme
Questionnaires « avant »	36	30 (83,3 %)	Six manquants : à recueillir avant l'atelier suivant
Supports FALC	4	3	Un support en retard

4. Exemples : déplacer les ateliers de la résidence B à un autre horaire (10 h ou samedi matin), choisi avec les mères ; à la résidence C, garder le groupe mais limiter à 9 places, ou réserver une salle plus grande pour

l'atelier final ; utiliser une partie du reste du budget pour une garde d'enfants pendant les ateliers de la résidence B.

Corrigé – Exercice 8.40

1. Légendes : 1 Objectifs de communication ; 2 Cibles ; 3 Messages ; 4 Canaux et supports ; 5 Calendrier ; 6 Budget et évaluation.
2. Exemples : faire connaître le réfrigérateur et ses règles à tous les habitants avant son ouverture ; obtenir l'engagement d'au moins quatre commerces donateurs ; informer les riverains pour prévenir les conflits ; valoriser l'action auprès des élus après six mois.
3. Plan de communication (exemple) :

Cible	Objectif	Message	Canal, support	Quand
Habitants	Connaître et utiliser le réfrigérateur sans gêne	« Ici, chacun donne et chacun prend. »	Affiche avec pictogrammes sur le réfrigérateur, journal municipal, relais du CCAS et des associations	Deux semaines avant l'ouverture, puis en continu
Commerces donateurs	S'engager à donner	« Moins de gaspillage, un geste visible pour votre commune. »	Rencontre en face à face, courrier de la mairie, convention simple	Un mois avant
Riverains	Accepter l'installation	« Un réfrigérateur entretenu chaque jour par des bénévoles ; un contact en cas de problème. »	Courrier dans les boîtes, rencontre sur place	Trois semaines avant
Élus	Soutenir et pérenniser	« En six mois, … kg de produits sauvés et partagés. »	Note de bilan, présentation en conseil municipal	Au bout de six mois

Le message aux habitants s'adresse à **tous** (« chacun donne et chacun prend ») : il ne désigne pas les personnes pauvres, ce qui évite la honte et la stigmatisation.

4. Exemples : nombre de commerces donateurs engagés ; nombre de personnes qui disent avoir connu le réfrigérateur par chaque canal (court questionnaire) ; nombre de plaintes de riverains.

Corrigé – Exercice 8.41

1. Contacts : 17 + 8 + 6 + 3 + 2 + 10 = **46** ; inscrits : 12 + 4 + 2 + 1 + 1 + 8 = **28**. Parts des inscriptions : relais 12 / 28 = **42,9 %** ; bouche-à-oreille 8 / 28 = **28,6 %** ; affiches 4 / 28 = **14,3 %** ; réseaux sociaux 2 / 28 = **7,1 %** ; flyers **3,6 %** ; radio **3,6 %**.
2. Taux de transformation : relais 12 / 17 = **70,6 %** ; affiches **50,0 %** ; réseaux sociaux **33,3 %** ; flyers **33,3 %** ; radio **50,0 %** ; bouche-à-oreille **80,0 %**. Coût par inscrit : relais 120 / 12 = **10,00 €** ; affiches 35 / 4 = **8,75 €** ; réseaux sociaux 72 / 2 = **36,00 €** ; flyers 60 / 1 = **60,00 €**.
3. Relais humains : (12 + 8) / 28 × 100 = **71,4 %** des inscriptions. Flyers : 3 contacts pour 400 flyers, soit **0,75 contact pour 100 flyers**.
4. Exemple : « Les relais humains apportent sept inscriptions sur dix, avec les meilleurs taux de transformation. Les flyers coûtent 60 € par inscrit et touchent très peu de personnes. L'an prochain, nous proposons de supprimer les flyers, de réduire le temps passé sur les réseaux sociaux, de garder les affiches, peu coûteuses, et d'investir les 60 € économisés dans la formation de deux relais supplémentaires. »
5. Limites : les effectifs sont petits (un inscrit de plus change fortement les pourcentages) ; une personne a pu être touchée par plusieurs canaux et n'en citer qu'un ; le coût des relais ne compte pas le temps qu'ils donnent.

Corrigé – Exercice 8.42

1. Commune : 1 000 × (1 − 0,30) = **700 €**. Coût monétaire d'un atelier si l'on achète les denrées : 400 + 50 = **450 €** ; pour huit ateliers : 8 × 450 = **3 600 €**.

2. Besoin supplémentaire : baisse de la commune 300 € + denrées à acheter 400 € = **700 €**. Les contributions en nature baissent de 400 € (comptes 86 et 87), sans effet sur l'équilibre.

3. Sept ateliers : charges monétaires = 2 000 + 7 × 450 = **5 150 €** ; contributions en nature : **500 €** ; total des charges : **5 650 €**. Participation : 1,50 × 15 × 7 = **157,50 €**. Produits connus : 2 500 + 700 + 800 + 157,50 + 500 = 4 657,50 € ; autofinancement nécessaire : 5 650 − 4 657,50 = **992,50 €** (contre 720 € prévus, soit 272,50 € de plus).

Charges	Montant	Produits	Montant
Charges fixes	2 000,00 €	74 – ARS	2 500,00 €
Sept ateliers (450 € chacun)	3 150,00 €	74 – Commune	700,00 €
86 – Salle et bénévolat	500,00 €	74 – CAF	800,00 €
		70 – Participation	157,50 €
		Autofinancement	992,50 €
		87 – Contributions en nature	500,00 €
Total	**5 650,00 €**	**Total**	**5 650,00 €**

4. Exemples : chercher un nouveau donateur de denrées (autre commerce, banque alimentaire, producteurs du marché), ce qui garde les huit ateliers ; demander à la CAF ou à une fondation un complément de 700 €. Ces solutions préservent l'action pour le public, mais elles sont incertaines et prennent du temps. Réduire à sept ateliers est sûr et rapide, mais diminue l'offre : on peut le décider à titre provisoire et rétablir le huitième atelier si un financement arrive.

5. Informer le comité de pilotage (qui décide), les financeurs (ARS, CAF, commune), les participants (si le calendrier change) et les bénévoles. L'ARS doit être informée parce que la subvention a été accordée pour un projet précis (huit ateliers) : toute modification importante du contenu ou du budget doit lui être signalée, et parfois validée par un avenant. Le bilan devra expliquer l'écart.

Partie 8 – Synthèse : du plan d'action au cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Compléter un cadre logique, l'outil des financeurs.
- Préparer la pérennisation dès la conception et chiffrer le coût d'une deuxième année.
- Organiser et valoriser l'engagement des bénévoles.
- Utiliser un tableur pour le budget et la trésorerie.
- Défendre son plan d'action devant le jury.
- Traiter un cas complet au format de l'épreuve : diagnostic, objectifs, planning, budget, trésorerie, repas (Ciqual 2025), risques et éthique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Cadre logique : un tableau à quatre colonnes (logique d'intervention, indicateurs, sources de vérification, hypothèses) et quatre lignes (objectif général, objectif spécifique, résultats, activités). Il vérifie la cohérence verticale (les activités produisent les résultats qui servent l'objectif) et horizontale (chaque niveau a ses indicateurs).
- Pérennisation : former des relais, rendre les outils réutilisables, inscrire l'action dans le projet de la structure, diversifier les financements, rechercher des financements pluriannuels (contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, fonds européens).
- Bénévoles : une mission claire, un accueil, une formation, un référent, une reconnaissance ; le bénévolat est valorisé aux comptes 86 et 87 avec un taux horaire justifié.
- Tableur : formules plutôt que valeurs saisies à la main ; une cellule par donnée ; vérification automatique de l'équilibre.
- À l'oral : relier chaque choix du plan d'action au diagnostic, montrer les chiffres, reconnaître les limites et dire ce que l'on ferait autrement.

Exercice 8.43 – Compléter un cadre logique (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une fondation (fictive) demande à l'association Bocal et Compagnie (exercices 8.21 et 8.38) de présenter son projet de cuisine mobile sous la forme d'un cadre logique. Le coordinateur a commencé le tableau.

Document 1 – Cadre logique à compléter

Niveau	Logique d'intervention	Indicateurs	Sources de vérification	Hypothèses
Objectif général	Contribuer à améliorer l'alimentation des habitants isolés de six villages	……	……	–
Objectif spécifique	Dans un an, 30 % des participants cuisinent au moins deux fois par semaine des légumes achetés aux producteurs locaux (valeur initiale : 12 %)	……	……	……
Résultats	……	6 villages desservis ; 4 producteurs partenaires	……	……
Activités	24 haltes de la cuisine mobile avec atelier et dégustation ; formation de 8 bénévoles	……	……	……

À vous de jouer – Questions

1. Complétez les cases vides du cadre logique. (6 pts)

2. Expliquez la différence entre un indicateur et une source de vérification. (2 pts)

3. Expliquez à quoi servent les hypothèses, avec un exemple. (2 pts)

Ma réponse

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

.....

Exercice 8.44 – Préparer la pérennisation (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

La première année du projet « Cuisine au cœur du bourg » (association fictive) a été financée en grande partie par une subvention qui ne sera pas renouvelée. Le bureau veut continuer huit ateliers en deuxième année, avec 12 participants par atelier, et vous demande un budget réaliste.

Document 1 – Charges monétaires de la première année et choix pour la deuxième année (fictifs)

Poste	Année 1	Choix pour l'année 2
Diététicienne	8 ateliers × 3 h × 55 €	3 ateliers × 3 h × 55 € ; les autres sont animés par l'animatrice et deux relais formés
Coordinatrice	60 h × 24 €	20 h × 24 € (outils déjà construits)
Animatrice	64 h × 18 €	64 h × 18 €
Denrées	8 × 40 €	8 × 40 €
Petit matériel	450 €	0 € (matériel acquis)
Communication	220 €	80 € (affiches réimprimées)
Formation des relais	2 séances × 3 h × 55 €	0 €

Ressources de l'année 2 : participation de 2 € par personne et par atelier ; la commune accorde 600 €.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les charges monétaires des deux années et la baisse en euros et en pourcentage. (4 pts)
2. Calculez la participation, puis l'autofinancement nécessaire en année 2, et sa part dans les charges. (3 pts)
3. Relevez dans le document 1 trois choix de l'année 1 qui ont préparé la pérennisation. (3 pts)
4. Proposez deux pistes de financement pour l'année 2. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.45 – Organiser et valoriser le bénévolat (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association Saveurs du Faubourg (exercice 8.42) s'appuie sur neuf bénévoles. Après deux départs l'an dernier, la présidente vous demande de mieux organiser leur engagement et de valoriser leur temps dans le budget (charges monétaires : 8 000 €). L'association a fixé à 15 € le taux horaire de valorisation (taux fictif, à justifier dans l'annexe du budget).

Document 1 – Temps des bénévoles prévu sur l'année

- 4 bénévoles aux ateliers : 8 ateliers de 3 heures chacun.
- 2 bénévoles à la logistique : 10 heures chacun.
- 3 bénévoles à la communication : 6 heures chacun.

Document 2 – Ce qu'ont dit les deux bénévoles partis

« On ne savait jamais ce qu'on devait faire en arrivant. » « Personne ne m'a dit merci, et je n'ai jamais su si les familles avaient aimé. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre d'heures de bénévolat et leur valorisation. (2 pts)
2. Calculez la part du bénévolat dans le budget total, contributions en nature comprises. (2 pts)
3. Indiquez comment le bénévolat apparaît dans le budget. (2 pts)
4. Proposez cinq mesures pour fidéliser les bénévoles, en vous appuyant sur le document 2. (4 pts)
5. Citez deux tâches qu'un bénévole ne doit pas assurer seul dans un atelier culinaire, et pourquoi. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.46 – Utiliser un tableur pour le budget et la trésorerie (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous construisez dans un tableur le suivi du budget du Clos-Fleuri (exercices 8.27 et 8.29) et un plan de trésorerie. Votre tutrice veut que le fichier se mette à jour seul quand on change une valeur.

Document 1 – Organisation de la feuille « Budget »

Ligne 1 : titres. Colonne A : postes. Colonne B : prévu. Colonne C : réalisé. Colonne D : écart en euros. Colonne E : écart en pourcentage. Lignes 2 à 9 : les huit postes de l'exercice 8.29. Ligne 10 : totaux.

Document 2 – Organisation de la feuille « Trésorerie »

Ligne 1 : titres. Colonne A : mois. Colonne B : encaissements. Colonne C : décaissements. Colonne D : solde de fin de mois. La cellule D1 contient le solde de départ (500 €). Lignes 2 à 9 : janvier à août.

À vous de jouer – Questions

1. Écrivez les formules des cellules D2, E2, B10 et D10 de la feuille « Budget ». (4 pts)
2. Écrivez la formule de la cellule D2 de la feuille « Trésorerie », puis celle de D3, recopiable vers le bas. (2 pts)
3. Proposez une formule qui affiche « équilibré » ou « déséquilibré » en comparant le total des charges (cellule H20) et le total des produits (cellule K20). (2 pts)
4. Proposez une mise en forme qui fait apparaître les soldes négatifs. (2 pts)
5. Donnez deux règles pour qu'un fichier partagé reste fiable. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.47 – Défendre son plan d'action devant le jury (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors du temps 1 de l'épreuve E5, après votre exposé de 10 minutes, le jury vous interroge pendant 20 minutes sur le plan d'action de votre projet de stage. Vous vous entraînez avec cinq questions fréquentes.

Document 1 – Cinq questions du jury

a) « Pourquoi avez-vous choisi des ateliers culinaires plutôt qu'une autre action ? »

b) « Votre budget repose à 70 % sur une seule subvention. Est-ce raisonnable ? »

c) « Votre taux de présence était de 62 %. Qu'avez-vous fait ? »

d) « Qui a décidé des horaires des ateliers ? »

e) « Si vous deviez recommencer, que changeriez-vous dans votre plan d'action ? »

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque question, dites ce que le jury cherche à vérifier. (5 pts)
2. Rédigez une réponse de trois à quatre phrases pour chaque question, appuyée sur des faits. (7,5 pts)
3. Indiquez trois erreurs à éviter pendant l'entretien. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.48 – Cas complet : le « bol du bénévole » d'un festival de musique (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 h*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage auprès de l'association qui organise « Les Nuits du Lac » (festival fictif de musique, trois soirs en juillet 2027, en zone rurale). Le festival repose sur 160 bénévoles, qui travaillent souvent de 16 h à 2 h du matin. L'an dernier, plusieurs malaises ont été signalés et beaucoup de bénévoles se sont plaints de la cantine. La coordinatrice vous confie, avec une diététicienne libérale, un projet pour l'alimentation et l'hydratation des bénévoles : un « bol du bénévole » servi chaque nuit à 23 h, des fontaines à eau et une gourde pour chacun. Le projet commence en semaine 0 (fin avril 2027).

Document 1 – Questionnaire de fin d'édition 2026 (données fictives) : 112 répondants sur 160 bénévoles

Réponse	Nombre
A sauté au moins un repas pendant le festival	47
A surtout mangé des chips ou des sandwichs la nuit	58
A bu moins d'un litre et demi d'eau par jour	63
A ressenti un malaise ou une grande fatigue	19
Est satisfait de la cantine	41
Trouve les horaires de la cantine inadaptés	66

Croisement : parmi les 48 bénévoles postés après 22 h, 29 ont sauté au moins un repas ; parmi les 64 autres, 18 sont dans ce cas.

Document 2 – Règles de financement (fictives)

- Fondation Terres et Fêtes : 50 % au plus des charges monétaires du projet, dans la limite de 3 000 € ; versement de 70 % à la signature (mai), le solde après le bilan (octobre).
- Communauté de communes : 1 200 € accordés, versés en septembre.
- Le festival complète par autofinancement. Il affecte au projet une trésorerie de 900 € au 1er avril.
- Un brasseur, partenaire du festival, propose de payer les gourdes si elles portent le logo de sa bière.

Document 3 – Les tâches du projet (durées en semaines)

Tâche	Intitulé	Durée	Antériorités
A	Analyse du questionnaire 2026	2	–
B	Choix des actions avec la coordinatrice	1	A
C	Dossier pour la fondation	2	B
D	Recherche de producteurs locaux	3	B
E	Conception du bol et des fiches	3	B
F	Commande des gourdes et location des fontaines	2	C
G	Formation de l'équipe de la cantine	1	D, E
H	Communication auprès des bénévoles	2	E
I	Festival	1	F, G, H
J	Bilan	2	I

Document 4 – Éléments du budget (fictifs)

- Denrées du bol : 480 portions (160 bénévoles × 3 nuits), coût à calculer (document 5).
- Gourdes : 160 × 2,10 €. Location de 3 fontaines à eau pendant 4 jours : 45 € par fontaine et par jour.
- Diététicienne : 2 jours de préparation de 7 h et 3 soirs de présence de 4 h, à 50 € de l'heure.
- Impression des affiches et des fiches : 180 €. Coordinatrice salariée : 40 h à 22,00 € de l'heure.
- Équipe de la cantine : 12 bénévoles × 3 jours × 6 h, valorisées à 14 € de l'heure. Cuisine de la salle des fêtes prêtée par la commune : valorisée 600 €.
- Jusqu'ici, le festival achetait à un traiteur un sandwich de minuit à 2,90 € pour chaque bénévole et chaque nuit (hors projet).

Document 5 – Le « bol du bénévole » : grammages nets par portion, pertes et prix (fictifs) et extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Net par portion	Perte	Prix	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Vitamine C (mg)
Riz complet, cru (9102)	60 g	–	2,40 € le kg	350	7,02	71,4	2,8	5	0,01	11,1	0
Haricot rouge, appertisé, égoutté (20524)	80 g	–	2,60 € le kg	108	8,31	13	0,97	7	0,68	58	0,2
Maïs doux, appertisé, égoutté (20066)	40 g	–	3,40 € le kg	105	2,66	18,3	1,68	3,1	0,59	3,51	2,1
Poivron rouge, cru (20087)	50 g	15 %	3,80 € le kg	33,6	1,06	5,98	< 0,5	3,2	< 0,013	4,8	121
Tomate sans précision, crue (20385)	60 g	5 %	2,90 € le kg	19,2	0,6	3,69	< 0,5	1,02	< 0,013	6,78	20,1
Huile de colza (17130)	6 g	–	3,20 € le kg	900	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0
Fromage blanc, nature, 2-3 % MG (19646)	60 g	–	2,60 € le kg	75,7	7,28	3,86	3,23	0,019	0,088	131	< 2
Nectarine ou brugnon, chair et peau, sans noyau, crue (13399)	150 g	8 %	3,20 € le kg	49,5	0,74	11,3	< 0,5	0,47	< 0,013	4,88	3,24

Citron, cumin, sel : forfait de 1,60 € pour 160 portions. On calcule avec les poids nets ; « < » est compté 0.

À vous de jouer – Questions

Partie A – Diagnostic et objectifs (8 points)

1. Calculez le taux de participation au questionnaire et les pourcentages du document 1. (2 pts)

2. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion de bénévoles qui ont sauté un repas. (1 pt)

3. Calculez le risque relatif de sauter un repas pour les bénévoles postés après 22 h, avec son intervalle de confiance à 95 % (formule : $\exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d)})$), et interprétez-le. (2 pts)

4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et deux objectifs opérationnels SMART. (3 pts)

Partie B – Planification (5 points)

5. Calculez les dates au plus tôt et au plus tard, les marges, le chemin critique et la durée minimale du projet.

(4 pts)

6. Le festival a lieu en semaine 10. Le projet est-il tenable ? Indiquez la marge disponible. (1 pt)

Partie C – Le bol du bénévole (9 points)

7. Établissez le bon de commande pour une nuit (160 portions) : poids net, poids brut, coût de chaque ligne au centime. Calculez le coût par portion et le coût des trois nuits. (3 pts)

8. Calculez les apports d'une portion (bol et nectarine) en énergie, protéines, glucides, lipides, fibres, sel, calcium et vitamine C, et la répartition de l'énergie. (4 pts)

9. Commentez ce repas pour un bénévole qui travaille la nuit, et proposez une modification pour augmenter les protéines ; calculez-en l'effet avec un œuf dur de 50 g (Ciqual 22010 : 134 kcal, 13,5 g de protéines, 8,62 g de lipides, 41 mg de calcium pour 100 g). (2 pts)

Partie D – Budget, financement et trésorerie (12 points)

10. Calculez chaque charge du projet et présentez le budget équilibré, contributions en nature comprises. (5 pts)

11. Calculez la subvention de la fondation et l'autofinancement du festival. Comparez avec la dépense de sandwichs évitée. (3 pts)

12. Construisez le plan de trésorerie d'avril à octobre (décaissements : avril 920 € ; mai 400 € ; juin 556 € ; juillet : le reste des charges monétaires) ; indiquez le besoin maximal et une solution propre à un festival. (4 pts)

Partie E – Risques, communication et éthique (6 points)

13. Identifiez trois risques propres à cette action et proposez une mesure pour chacun. (3 pts)

14. Rédigez le message de communication adressé aux bénévoles, et indiquez deux canaux. (1,5 pt)

15. Que répondez-vous au brasseur (document 2) ? Justifiez. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 8.43

1. Cadre logique complété (exemple) :

Niveau	Logique d'intervention	Indicateurs	Sources de vérification	Hypothèses
Objectif général	Contribuer à améliorer l'alimentation des habitants isolés de six villages	Évolution de la consommation de fruits et de légumes des habitants participants	Enquête au début et à la fin du projet	–
Objectif spécifique	30 % des participants cuisinent au moins deux fois par semaine des légumes des producteurs locaux (valeur initiale 12 %)	Part des participants qui déclarent cuisiner ces légumes au moins deux fois par semaine	Questionnaire avant/après	Les producteurs maintiennent des prix accessibles
Résultats	La cuisine mobile dessert six villages ; quatre producteurs vendent sur les haltes ; les habitants savent cuisiner les légumes de saison	6 villages desservis ; 4 producteurs partenaires ; part des participants capables de réaliser une recette	Planning des haltes, conventions, grille d'observation des ateliers	Les mairies prêtent un emplacement ; les habitants viennent aux haltes
Activités	24 haltes avec atelier et dégustation ; formation de 8 bénévoles	24 haltes réalisées ; 8 bénévoles formés ; nombre de participants par halte	Feuilles d'émargement, compte rendu de formation	Le camion est en état ; les bénévoles restent disponibles

2. L'**indicateur** est ce que l'on mesure (une part, un nombre) ; la **source de vérification** est le document ou l'outil qui permet de le mesurer et de le prouver (questionnaire, feuille d'émargement, convention).

3. Les hypothèses sont les conditions extérieures, hors du contrôle de l'équipe, nécessaires pour passer d'un niveau au suivant. Exemple : si les mairies refusent un emplacement, les haltes ne pourront pas avoir lieu, même si l'équipe est prête. Elles sont reliées à la matrice des risques.

Corrigé – Exercice 8.44

1. Année 1 : diététicienne 8 × 3 × 55 = 1 320 € ; coordinatrice 60 × 24 = 1 440 € ; animatrice 64 × 18 = 1 152 € ; denrées 8 × 40 = 320 € ; matériel 450 € ; communication 220 € ; formation 2 × 3 × 55 = 330 € ; total **5 232 €**. Année 2 : diététicienne 3 × 3 × 55 = 495 € ; coordinatrice 20 × 24 = 480 € ; animatrice 1 152 € ; denrées 320 € ; communication 80 € ; total **2 527 €**. Baisse : 5 232 − 2 527 = **2 705 €**, soit 2 705 / 5 232 × 100 = **51,7 %**.

2. Participation : 2 € × 12 × 8 = **192 €**. Autofinancement : 2 527 − 192 − 600 = **1 735 €**, soit 1 735 / 2 527 × 100 = **68,7 %** des charges.

3. La formation de deux relais (qui animent désormais cinq ateliers) ; l'achat de matériel durable ; la construction des outils par la coordinatrice (conducteurs, fiches, affiches réutilisables).

4. Exemples : déposer une demande à la conférence des financeurs si le public a plus de 60 ans, ou à la CAF s'il s'agit de familles ; inscrire l'action dans le contrat local de santé ou le projet alimentaire territorial ; solliciter une caisse de retraite ou une mutuelle ; demander à la commune une convention sur trois ans.

Corrigé – Exercice 8.45

1. Heures : 4 × 8 × 3 = 96 h ; 2 × 10 = 20 h ; 3 × 6 = 18 h ; total **134 heures**. Valorisation : 134 × 15 = **2 010 €**.

2. Budget total : 8 000 + 2 010 = 10 010 € ; part du bénévolat : 2 010 / 10 010 × 100 = **20,1 %**.

3. Au **compte 86** (emplois des contributions volontaires en nature, côté charges) et au **compte 87**

(contributions volontaires en nature, côté produits), pour 2 010 € de chaque côté. Le taux de 15 € et le nombre d'heures sont justifiés dans l'annexe.

4. Exemples : une fiche mission pour chaque poste (ce que l'on attend, horaires, référent) ; un accueil avant le premier atelier et un point de dix minutes au début de chaque séance ; une courte formation (hygiène, accueil du public, gestes de sécurité) ; un retour sur ce que les familles ont dit et sur les résultats du projet ; une reconnaissance (remerciements publics, repas des bénévoles, attestation d'engagement) ; une place au comité de pilotage pour un représentant des bénévoles.
5. Exemples : la gestion d'une allergie ou d'un malaise (il faut connaître le protocole et appeler les secours) ; le conseil nutritionnel individuel (il relève de la diététicienne) ; la sécurité des gestes dangereux (four, friture, couteaux) avec un groupe entier.

Corrigé – Exercice 8.46

1. D2 : =C2-B2 ; E2 : =D2/B2 (format pourcentage) ou =(C2-B2)/B2*100 ; B10 : =SOMME(B2:B9) ; D10 : =C10-B10 (ou =SOMME(D2:D9)).
2. D2 : =D1+B2-C2 ; D3 : =D2+B3-C3, à recopier vers le bas jusqu'à D9.
3. =SI(H20=K20;"équilibré";"déséquilibré") ; pour éviter les erreurs d'arrondi : =SI(ARRONDI(H20-K20;2)=0;"équilibré";"déséquilibré").
4. Une mise en forme conditionnelle : si la valeur de la cellule est inférieure à 0, police rouge et fond rose ; on peut aussi utiliser le format de nombre « 0,00 € ;[Rouge]-0,00 € ».
5. Exemples : ne jamais écrire un résultat à la main là où une formule est prévue ; garder une seule version partagée, avec la date de mise à jour ; protéger les cellules de formules ; noter les sources des données (devis, factures) ; faire vérifier les totaux par une deuxième personne.

Corrigé – Exercice 8.47

1. a) La cohérence entre l'action et le diagnostic, et la connaissance des données probantes. b) La compréhension des règles de prudence et de cofinancement. c) La capacité à piloter : repérer un écart, en chercher les causes, décider. d) La participation du public. e) La capacité d'analyse critique et de recul.
2. Exemples de réponses :

a) « Le diagnostic montrait que 71 % des personnes ne savaient pas préparer les légumes secs, alors que l'épicerie en disposait. Une information seule n'aurait pas donné ce savoir-faire. Les ateliers culinaires sont une méthode active, recommandée pour les savoir-faire, et je les ai combinés avec des dégustations à l'épicerie pour agir aussi sur l'accès. »

b) « Ce n'est pas idéal : si la subvention avait été refusée, le projet aurait été réduit de moitié. J'ai distingué les financements acquis et sollicités, et prévu une version à quatre ateliers. Pour l'an prochain, nous avons déposé une demande à la CAF pour diversifier les ressources. »

c) « J'ai calculé le taux après chaque atelier : 62 %, pour un objectif de 80 %. Les appels aux absentes ont montré que l'horaire de 14 h tombait pendant la sortie de l'école. Le comité de pilotage a déplacé les ateliers à 9 h 30, et le taux est remonté à 81 % sur les trois derniers ateliers. »

d) « Les horaires ont été choisis avec trois participantes lors d'une réunion de préparation, puis confirmés avec le groupe. Quand ils ne convenaient plus, nous les avons changés sur leur proposition. »

e) « J'associerais les participantes dès le choix des actions, et pas seulement des horaires. Je prévoirais plus de temps pour les inscriptions, que j'avais sous-estimé de près de 20 %, et je préparerais le questionnaire "après" dès le début. »

3. Exemples : réciter le dossier sans répondre à la question ; se justifier sans reconnaître une limite réelle ; donner un chiffre sans savoir le recalculer ; parler des participants de façon stigmatisante ; couper la parole au jury.

Corrigé – Exercice 8.48

Partie A

1. Participation : 112 / 160 × 100 = **70,0 %**. Pourcentages (sur 112 répondants) : repas sauté **42,0 %** ; chips ou sandwichs la nuit **51,8 %** ; moins d'un litre et demi d'eau **56,3 %** (63 / 112 = 56,25 %) ; malaise ou grande fatigue **17,0 %** ; satisfaits de la cantine **36,6 %** ; horaires inadaptés **58,9 %**.

2. p = 47 / 112 = 0,420 ; marge = 1,96 × √(0,420 × 0,580 / 112) = **0,091**, soit **± 9,1 points** ; intervalle : **32,9 % à 51,1 %**. Entre un tiers et la moitié des bénévoles ont probablement sauté un repas. Les 48 non-répondants sont peut-être différents (biais de non-réponse).

3. Postés après 22 h : 29 / 48 = 60,4 % ; autres : 18 / 64 = 28,1 % ; RR = 60,4 / 28,1 = **2,15**. Erreur type : √(1/29 − 1/48 + 1/18 − 1/64) = 0,234 ; IC à 95 % : exp(ln 2,15 ± 1,96 × 0,234) = **[1,36 ; 3,38]**. Les bénévoles postés la nuit ont environ deux fois plus de risque de sauter un repas ; l'intervalle ne contient pas 1 : la différence est statistiquement significative. Cela justifie un repas servi à 23 h.

4. Exemple. Objectif général : contribuer à préserver la santé des bénévoles du festival. OS1 : lors de l'édition 2027, réduire de 42 % à 20 % la part des bénévoles qui sautent au moins un repas (questionnaire de fin d'édition). OS2 : lors de l'édition 2027, réduire de 56 % à 30 % la part des bénévoles qui boivent moins d'un litre et demi d'eau par jour. Objectifs opérationnels : servir chaque nuit à 23 h, pendant les trois nuits, 160 bols du bénévole, soit 480 portions ; installer trois fontaines à eau et remettre une gourde à chacun des 160 bénévoles avant le premier soir.

Partie B

5. Calculs (en semaines) :

Tâche	Début au plus tôt	Fin au plus tôt	Début au plus tard	Fin au plus tard	Marge
A (2)	0	2	0	2	0
B (1)	2	3	2	3	0
C (2)	3	5	4	6	1
D (3)	3	6	4	7	1
E (3)	3	6	3	6	0
F (2)	5	7	6	8	1
G (1)	6	7	7	8	1
H (2)	6	8	6	8	0
I (1)	max(7 ; 7 ; 8) = 8	9	8	9	0
J (2)	9	11	9	11	0

Chemin critique : **A → B → E → H → I → J** ; durée minimale : 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 2 = **11 semaines**.

6. Le festival (I) peut commencer au plus tôt en semaine 8 ; s'il a lieu en semaine 10, il reste **2 semaines de marge** pour l'ensemble des tâches qui le précèdent. Le projet est tenable, à condition de ne pas dépasser ces deux semaines de retard sur la conception du bol et la communication.

Partie C

7. Bon de commande pour 160 portions : riz complet 9,6 kg × 2,40 = **23,04 €** ; haricots rouges 12,8 kg × 2,60 = **33,28 €** ; maïs 6,4 kg × 3,40 = **21,76 €** ; poivrons 8,0 kg net, 8,0 / 0,85 = 9,41 kg brut × 3,80 = **35,76 €** ; tomates 9,6 kg net, 9,6 / 0,95 = 10,11 kg brut × 2,90 = **29,31 €** ; huile 0,96 kg × 3,20 = **3,07 €** ; fromage blanc 9,6 kg × 2,60 = **24,96 €** ; nectarines 24,0 kg net, 24,0 / 0,92 = 26,09 kg brut × 3,20 = **83,48 €** ; forfait **1,60 €**. Total par nuit : **256,26 €** ; par portion : 256,26 / 160 = **1,60 €** ; trois nuits : 3 × 256,26 = **768,78 €**.

8. Apports d'une portion : énergie **540,4 kcal** ; protéines **18,29 g** ; glucides **85,03 g** ; lipides **11,07 g** ; fibres **12,77 g** ; sel **0,84 g** ; calcium **146,9 mg** ; vitamine C **78,4 mg**. Exemple : énergie du riz = 60 × 350 / 100 = 210 kcal ; vitamine C du poivron = 50 × 121 / 100 = 60,5 mg. Répartition : protéines 18,29 × 4 / 540,4 = **13,5 %** ; lipides 11,07 × 9 / 540,4 = **18,4 %** ; glucides 85,03 × 4 / 540,4 = **62,9 %** ; fibres environ 4,7 %.

9. Le repas est riche en glucides complexes et en fibres (riz complet, haricots rouges), utiles pour tenir

pendant un effort prolongé ; il apporte beaucoup de vitamine C et peu de sel ; il se mange froid, se prépare à l'avance et se sert vite, ce qui convient à une pause courte. Les protéines (13,5 % de l'énergie) et les lipides sont un peu bas pour un repas principal. Avec un œuf dur de 50 g : protéines 18,29 + 6,75 = **25,04 g** (16,5 % de l'énergie) ; énergie 540,4 + 67 = **607,4 kcal** ; lipides 11,07 + 4,31 = **15,38 g** ; calcium **167,4 mg**. Coût supplémentaire : le prix d'un œuf (environ 0,30 €, prix fictif), soit environ 1,90 € par portion.

Partie D

10. Charges : denrées 768,78 € ; gourdes 160 × 2,10 = 336,00 € ; fontaines 3 × 4 × 45 = 540,00 € ; diététicienne (2 × 7 + 3 × 4) × 50 = 26 × 50 = 1 300,00 € ; impression 180,00 € ; coordinatrice 40 × 22,00 = 880,00 € ; bénévolat 12 × 3 × 6 × 14 = 3 024,00 € ; cuisine prêtée 600,00 €.

Charges	Montant	Produits	Montant
60 – Denrées du bol	768,78 €	74 – Fondation Terres et Fêtes (sollicitée)	2 002,39 €
60 – Gourdes	336,00 €	74 – Communauté de communes (acquise)	1 200,00 €
61 – Location des fontaines	540,00 €	Autofinancement du festival	802,39 €
62 – Honoraires de la diététicienne	1 300,00 €	87 – Bénévolat	3 024,00 €
62 – Impression	180,00 €	87 – Mise à disposition de la cuisine	600,00 €
64 – Coordinatrice	880,00 €		
86 – Bénévolat	3 024,00 €		
86 – Mise à disposition de la cuisine	600,00 €		
Total	**7 628,78 €**	**Total**	**7 628,78 €**

11. Charges monétaires : 768,78 + 336 + 540 + 1 300 + 180 + 880 = **4 004,78 €**. Fondation : 50 % × 4 004,78 = **2 002,39 €**, inférieur au plafond de 3 000 €. Autofinancement : 4 004,78 − 2 002,39 − 1 200 = **802,39 €**. Sandwichs évités : 480 × 2,90 = **1 392 €** ; le festival économise donc 1 392 − 802,39 = **589,61 €** par rapport à l'an dernier, tout en offrant un repas plus complet.

12. Fondation : 70 % × 2 002,39 = 1 401,67 € en mai ; solde 600,72 € en octobre. Décaissements de juillet : 4 004,78 − 920 − 400 − 556 = 2 128,78 €.

Mois	Encaissements	Décaissements	Solde de fin de mois
Avril	0	920,00	900 − 920 = − 20,00
Mai	1 401,67	400,00	981,67
Juin	0	556,00	425,67
Juillet	0	2 128,78	− 1 703,11
Août	0	0	− 1 703,11
Septembre	1 200,00	0	− 503,11
Octobre	600,72	0	97,61

Besoin maximal : **1 703,11 €** en juillet et en août. Solution propre au festival : les recettes de la billetterie et de la buvette sont encaissées en juillet ; le festival peut avancer cette somme sur sa trésorerie générale. On peut aussi demander à la communauté de communes un versement en juillet. Vérification : 900 + 1 401,67 + 1 200 + 600,72 − 4 004,78 = 97,61 € ; les 900 € apportés couvrent l'autofinancement de 802,39 € et il reste 97,61 €.

Partie E

13. Exemples : chaleur et rupture de la chaîne du froid (fromage blanc, riz cuit) : préparation l'après-midi, stockage au froid, service dans les deux heures, relevé des températures, jamais de riz cuit gardé à température ambiante (*Bacillus cereus*) ; faible consommation du bol par les bénévoles postés loin de la cantine : distribution au poste par une équipe mobile ; allergies (lait, céleri éventuel dans les épices) :

affichage des allergènes, version sans fromage blanc ; malaise d'un bénévole : lien avec le poste de secours, rappel de boire à chaque prise de poste.

14. Exemple : « Cette année, on prend soin de ceux qui font le festival : à 23 h, ton bol t'attend à la cantine, ou il vient à toi à ton poste. Ta gourde se remplit aux trois fontaines. » Canaux : le groupe de messagerie des bénévoles et la réunion d'accueil du premier jour ; affiches à la cantine et aux fontaines.

15. Refuser poliment : associer une marque de bière à un objet de prévention santé remis à tous les bénévoles serait contradictoire avec l'objectif, et la publicité pour les boissons alcoolisées est strictement encadrée en France par la loi Évin (loi n° 91-32 du 10 janvier 1991). On peut proposer au brasseur de soutenir le projet autrement, sans logo sur les gourdes (par exemple en finançant les fontaines à eau, avec une simple mention dans le bilan), ou chercher un autre financeur.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Classer des actions dans les six stratégies ; rédiger une fiche QQOQCCP chiffrée ; choisir une action avec des critères ; relier actions et objectifs ; adapter une action à un public ; rédiger un plan d'action	8.1 à 8.6			
2	Construire une matrice pouvoir/intérêt ; organiser les instances de pilotage ; corriger une matrice RACI ; corriger une convention ; convaincre un partenaire ; rédiger un compte rendu	8.7 à 8.12			
3	Répondre à un appel à projets ; choisir le financeur ; vérifier l'éligibilité ; calculer une subvention avec un plafond et un taux ; construire un plan de financement ; relire un dossier	8.13 à 8.18			
4	Lire et calculer un réseau PERT ; construire un Gantt ; mesurer l'effet d'un retard ; estimer une charge de travail ; fixer un calendrier réel	8.19 à 8.24			
5	Classer les comptes ; calculer un coût horaire chargé ; construire un budget équilibré ; calculer des ratios ; analyser des écarts ; calculer un seuil de participants	8.25 à 8.30			
6	Construire un plan de trésorerie ; calculer des quantités brutes ; préparer la logistique et le conducteur ; choisir une méthode pédagogique ; calculer coût et apports avec la table Ciqual	8.31 à 8.36			
7	Lire un tableau de bord ; construire une matrice des risques ; analyser un suivi multisite ; construire un plan de communication ; mesurer l'efficacité des canaux ; réagir à un imprévu	8.37 à 8.42			
8	Compléter un cadre logique ; préparer la pérennisation ; organiser le bénévolat ; utiliser un tableur ; défendre un plan d'action ; traiter un cas complet	8.43 à 8.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5

CHAPITRE

08

Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage

Démarche de projet (2) | Stratégies | Partenaires | Financements | Calendrier

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 8 224
Mode d'emploi du cahier d'annales 224
Ce que le jury attend sur ce chapitre 224
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 226
S1 – « On cultive des légumes qu'on ne mange pas » : concevoir et piloter un projet alimentation dans un chantier d'insertion maraîcher 226
S2 – « Mes mains tremblent, mais je veux encore cuisiner » : un atelier culinaire pour des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches 230
S3 – « On commence à 5 heures, on mange à 9 heures, et encore » : piloter à mi-parcours un projet pour les agents de propreté d'une ville et animer un atelier de collation 234
Partie II – Les corrigés détaillés 239
Corrigé S1 – « On cultive des légumes qu'on ne mange pas » : concevoir et piloter un projet alimentation dans un chantier d'insertion maraîcher 239
Corrigé S2 – « Mes mains tremblent, mais je veux encore cuisiner » : un atelier culinaire pour des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches 246
Corrigé S3 – « On commence à 5 heures, on mange à 9 heures, et encore » : piloter à mi-parcours un projet pour les agents de propreté d'une ville et animer un atelier de collation 252
Grille d'auto-évaluation 259

Cahier d'annales E5 – chapitre 8

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les appels à projets, les budgets et les données des enquêtes sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« On cultive des légumes qu'on ne mange pas » : concevoir et piloter un projet alimentation dans un chantier d'insertion maraîcher	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Mes mains tremblent, mais je veux encore cuisiner » : un atelier culinaire pour des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« On commence à 5 heures, on mange à 9 heures, et encore » : piloter à mi-parcours un projet pour les agents de propreté d'une ville et animer un atelier de collation	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 8 porte sur la deuxième partie de la démarche de projet : passer des objectifs à un plan d'action réaliste, financé et piloté. Le jury vérifie que le candidat sait **organiser** les actions (QQOQCCP, répartition des rôles, matrice RACI), **associer les partenaires** et les financeurs pertinents, **lire un appel à projets** et en respecter les règles (plafond, taux, calendrier de versement), **planifier** (Gantt, PERT, chemin critique, marges), **construire un budget équilibré** avec les bons comptes et les contributions volontaires en nature, **anticiper la trésorerie**, **piloter** avec un tableau de bord et une analyse des écarts, **gérer les risques** et **communiquer** avec chaque public. Il valorise les calculs posés et vérifiés, les décisions argumentées par les chiffres et le respect de l'éthique (confidentialité, indépendance vis-à-vis des financeurs) ; il pénalise les budgets déséquilibrés, les plannings sans dépendances et les indicateurs sans valeur cible.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; repérer la demande, le public, les ressources, le financeur et ses règles ; surligner chaque donnée chiffrée et sa source (fictive ou réelle). Pendant : pour chaque calcul, écrire la formule, le calcul posé, le résultat arrondi et une phrase d'interprétation ; vérifier que le budget est équilibré, que les comptes 86 et 87 sont égaux et que la trésorerie reste positive mois par mois ; donner pour chaque

indicateur une valeur cible et une échéance. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « On cultive des légumes qu'on ne mange pas » : concevoir et piloter un projet alimentation dans un chantier d'insertion maraîcher

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E4 (dossier de projet : plan d'action, budget, calendrier) et E5.A (étude de cas en santé publique).

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année aux « Jardins du Pré-Haut » (association et territoire fictifs), un atelier chantier d'insertion qui cultive 6 hectares de légumes biologiques et les vend en paniers à des adhérents. Les salariés en insertion y travaillent pendant 4 à 24 mois pour reprendre pied dans l'emploi. L'accompagnatrice socioprofessionnelle vous dit : « C'est absurde : ils cultivent des légumes toute la journée et ils n'en mangent jamais. Beaucoup ne déjeunent pas, certains n'ont pas de cuisine chez eux. » Le diagnostic a été réalisé avant votre arrivée (document 2). Votre mission : concevoir le plan d'action, le calendrier, le budget et le pilotage du projet, et préparer la réponse à un appel à projets.

Document 1 – La structure, le public et les moyens

- 24 salariés en insertion (contrat à durée déterminée d'insertion, 26 heures par semaine, du lundi au jeudi, de 8 h à 15 h 30, pause de 30 minutes à midi) : 17 hommes et 7 femmes, de 19 à 58 ans ; 9 vivent en foyer ou en hébergement d'urgence, 6 en logement sans cuisine équipée.
- Encadrement : 2 encadrants techniques maraîchers ; 1 encadrante technique formée à la cuisine collective (salaire brut mensuel 2 100 € ; charges patronales estimées à 40 % du brut par la direction) ; 1 accompagnatrice socioprofessionnelle (coût horaire communiqué par la direction : 22,40 €) ; une vingtaine de bénévoles adhérents.
- Locaux : une salle de pause avec deux plaques électriques, un four à micro-ondes et un réfrigérateur ; une cuisine pédagogique est disponible gratuitement dans la salle des fêtes de la commune, à 400 mètres, le mardi (valeur locative estimée par la commune : 15 € de l'heure).
- Partenaires possibles : une diététicienne libérale (45 € de l'heure, déplacements compris) ; l'épicerie sociale de la ville voisine ; le service insertion du conseil départemental ; la mission locale ; le centre communal d'action sociale ; une fondation d'entreprise créée par une enseigne de grande distribution.

Document 2 – Diagnostic réalisé auprès des salariés en insertion (données fictives, janvier 2028)

Questionnaire oral de 15 questions, passé en entretien individuel par l'accompagnatrice ; 21 répondants sur 24 salariés.

Résultat	Effectif (n = 21)
Ne prend pas de repas le midi au moins 3 jours sur 4	12
N'a pas de cuisine équipée à domicile ou ne peut pas l'utiliser	15
N'a jamais cuisiné de légumes frais	9
Mange des légumes moins d'une fois par jour	16

Résultat	Effectif (n = 21)
Dépense moins de 40 € par semaine pour se nourrir	14
Prendrait un panier de légumes s'il était à prix réduit	17
Est intéressé par un atelier de cuisine pendant le temps de travail	13

Paroles recueillies : « Le midi je fume une cigarette, ça coupe la faim. » « Des courgettes, je ne sais pas quoi en faire. » « Au foyer, on n'a qu'un micro-ondes pour trente. » « Si c'est pendant les heures payées, je viens. »

Document 3 – Extrait d'un appel à projets (version adaptée et fictive pour le sujet)

Appel à projets « Bien manger dans les parcours d'insertion » – année 2028.

- **Publics prioritaires** : personnes en situation de précarité, notamment salariés des structures d'insertion par l'activité économique.
- **Actions éligibles** : ateliers de cuisine, accès à des produits frais à prix réduit, formation des encadrants, actions associant les bénéficiaires à la conception.
- **Actions exclues** : achats d'équipement lourd (plus de 1 000 € par article), actions ponctuelles sans suivi, distribution seule sans accompagnement.
- **Financement** : 2 500 € au plus, et 60 % au plus des charges monétaires du projet (les contributions en nature ne sont pas prises en compte dans ce calcul). Cofinancement obligatoire.
- **Versement** : 60 % à la notification, prévue en avril ; le solde après réception du bilan, prévu en octobre.
- **Critères de sélection** : diagnostic chiffré (20 %), cohérence objectifs-actions (25 %), partenariats engagés (15 %), participation des bénéficiaires (15 %), évaluation (15 %), budget réaliste et cofinancé (10 %).
- **Date limite de dépôt** : fin de la 6e semaine du projet. Formulaire de demande de subvention des associations (Cerfa n° 12156) joint au dossier.

Document 4 – Tâches du projet (durées en semaines)

Tâche	Intitulé	Durée	Antériorités
A	Diagnostic complémentaire et réunion de lancement	2	–
B	Choix des actions et fiches actions	1	A
C	Rédaction et dépôt du dossier d'appel à projets	3	B
D	Convention avec la diététicienne et l'épicerie sociale	2	B
E	Achat du petit matériel et organisation de la cuisine	4	A
F	Communication et inscriptions des salariés	2	C, D
G	Formation de l'encadrante aux règles d'hygiène des ateliers	1	E, F
H	Cycle de 8 ateliers et paniers solidaires	12	G
I	Évaluation et bilan	3	H
J	Création du livret de recettes illustré	2	G

Document 5 – Éléments chiffrés pour le budget (devis et estimations, données fictives)

- Encadrante technique cuisine : 60 heures sur le projet ; durée légale de 35 heures par semaine.
- Accompagnatrice socioprofessionnelle : 24 heures.
- Diététicienne libérale : 8 séances de 3 heures.
- Denrées des ateliers : 8 ateliers × 12 portions × 2,10 € par portion.
- Petit matériel de cuisine : 420 € ; boîtes de conservation : 24 × 6,50 €.
- Paniers solidaires : 24 salariés × 10 semaines ; le salarié paie 1 € par panier et la structure prend à sa

charge 1,50 € par panier.

- Impression du livret : 30 exemplaires × 4,80 € ; assurance de l'activité : 90 € ; déplacements pour une visite de marché : 60 €.
- Contributions en nature : cuisine de la salle des fêtes, 24 heures ; légumes du jardin utilisés en atelier, 96 portions valorisées à 0,60 € ; bénévolat, 20 heures valorisées à 12 €.
- Financements : appel à projets du document 3 (montant à déterminer) ; conseil départemental, 800 € (acquis, versés en février) ; fondation d'entreprise, 600 € (sollicités, versement prévu en mai) ; le reste en fonds propres de l'association.
- Trésorerie disponible pour le projet au 1er janvier : 400 €. Décaissements prévus (hors contributions en nature) : janvier 180 € ; février 650 € ; mars 1 050 € ; avril 820 € ; mai 760 € ; juin, le reste des charges monétaires.

Document 6 – Résultats d'un essai mené l'an dernier (données fictives)

L'an dernier, 10 salariés volontaires ont reçu pendant 8 semaines un panier hebdomadaire accompagné d'une fiche recette ; 11 salariés n'en ont pas reçu. À la fin, 7 des 10 salariés avec panier et 3 des 11 salariés sans panier déclaraient manger des légumes au moins une fois par jour. Les salariés avec panier étaient volontaires ; ceux sans panier ne l'avaient pas demandé.

Document 7 – Risques repérés par l'équipe

Risque	Probabilité (1 à 4)	Gravité (1 à 4)
R1 – Abandon de salariés en cours de cycle (sortie du chantier, absence)	3	3
R2 – Retard de notification de la subvention	3	3
R3 – Intoxication alimentaire en atelier	1	4
R4 – Mauvaise récolte (moins de légumes disponibles)	2	2
R5 – Absence de l'encadrante formée	2	3

Document 8 – Repères utiles (données réelles)

- Formulaire Cerfa n° 12156 : demande de subvention des associations ; le budget prévisionnel suit le plan comptable associatif (charges 60 à 64 et 86 ; produits 70, 74, 75 et 87), équilibré, avec des contributions volontaires en nature identiques aux comptes 86 et 87.
- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des légumes secs au moins deux fois par semaine.
- Programme national nutrition santé 2026-2030 (PNNS 5, lancé le 8 avril 2026) : réduire les inégalités sociales de santé en nutrition et faire des milieux de vie des espaces favorables à la santé.
- Intervalle de confiance du risque relatif : $\exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d)})$.
- Matrice RACI : R réalise, A approuve et rend compte (une seule personne A par tâche), C est consulté, I est informé.

Travail à faire

Partie A – Le projet d'intervention (dossier écrit de 10 pages au plus) – C3.1 (9 points)

1. Calculez le taux de réponse et les pourcentages du document 2. Formulez le problème central, l'objectif général et trois objectifs spécifiques SMART. Choisissez quatre actions qui combinent au moins trois stratégies différentes, et décrivez l'une d'elles avec la méthode QQOQCCP. (2 pts)

2. Placez les parties prenantes dans la matrice pouvoir-intérêt et établissez la matrice RACI de six tâches du projet. (1,5 pt)

3. Calculez les dates au plus tôt, au plus tard et les marges des tâches du document 4 ; déterminez la durée minimale du projet et le chemin critique. Vérifiez que la date limite de dépôt du document 3 peut être respectée et commentez la tâche J. (2 pts)

4. Établissez le budget prévisionnel équilibré (comptes du plan comptable associatif) ; calculez le montant de la subvention demandée en respectant les règles du document 3 ; calculez trois ratios et commentez. (2 pts)

5. Établissez le plan de trésorerie de janvier à juin ; repérez le besoin de trésorerie et proposez deux solutions. Calculez la criticité des risques du document 7, classez-les et proposez une mesure pour les trois premiers. (1,5 pt)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée – C3.3 (3 points)

6. Calculez le risque relatif du document 6 et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez, puis expliquez pourquoi ce résultat ne prouve pas l'efficacité du panier. (1,5 pt)

7. Proposez un protocole d'évaluation du nouveau projet (indicateurs de processus et de résultat, outils, moments de mesure, comparaison) qui corrige les limites de l'essai. (1,5 pt)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

8. Organisez une veille sur les appels à projets et les financements de la prévention en nutrition pour les publics en insertion : sources, outils, fréquence, partage dans l'équipe. (2 pts)

Partie D – Communication et posture professionnelle – C3.5 et C3.6 (3 points)

9. Élaborez le plan de communication du projet (cibles, objectifs, messages, canaux, calendrier). Analysez la proposition de financement par la fondation d'une enseigne de distribution : intérêts, risques et conditions à poser. (1,5 pt)

10. Rédigez la trame minutée de votre exposé de 10 minutes et listez 12 questions probables du jury, avec les éléments de réponse attendus pour quatre d'entre elles. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Mes mains tremblent, mais je veux encore cuisiner » : un atelier culinaire pour des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des sujets U62 et E5.B (bon de commande, mise à l'échelle et rendement, fiche technique, organisation dans le temps, hygiène) et du BTS blanc CNED E5B (calcul nutritionnel).

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'antenne départementale d'une association de personnes atteintes de la maladie de Parkinson (association fictive « Parkinson Ensemble 37 ») organise chaque mois une rencontre pour ses adhérents et leurs proches aidants. À la suite d'une enquête (document 5), le bureau vous demande de concevoir et d'animer un atelier culinaire qui permette aux participants de **continuer à cuisiner malgré les tremblements et la lenteur des gestes**, de **préparer des repas faciles à mâcher et à avaler**, riches en fibres et en eau, et de **partager un moment convivial** entre malades et aidants. Le président prévient : « Ici, on ne parle pas de la maladie toute la journée. On veut des recettes, et du plaisir. »

Document 1 – Le public et les contraintes

- 10 participants : 6 personnes atteintes de la maladie de Parkinson (58 à 79 ans) et 4 proches aidants ; on prévoit 12 portions (participants, la bénévole qui co-anime et vous).
- Monsieur R., 72 ans, a perdu 5 kg en un an ; il se fatigue vite pendant les repas.
- Madame L., 66 ans, tousse parfois en buvant et en mangeant des aliments secs ; son orthophoniste lui a conseillé des textures tendres et humides.
- Monsieur G., 61 ans, prend un traitement par lévodopa et a des périodes de blocage dans la journée ; son neurologue lui a demandé de prendre ses comprimés à distance des repas riches en protéines.
- Madame V., 70 ans, a un diabète de type 2 traité par comprimés.
- Monsieur N., aidant de son épouse, ne mange pas de poisson.
- Plusieurs participants ont des tremblements des mains ; deux se déplacent avec une canne.
- Salle d'activité de la maison des associations : 1 plaque à induction de deux feux, 1 four, 1 réfrigérateur, 3 tables de travail à hauteur assise, un évier ; pas de robot ni de mixeur plongeant (vous pouvez en apporter un).
- Budget denrées : au plus 3,80 € par portion.
- Durée de l'atelier avec les participants : 2 h, de 14 h à 16 h, dégustation comprise, avec une pause ; le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 2 – Menu imposé

Entrée : velouté de potiron.

Plat : parmentier de cabillaud aux poireaux, gratiné à l'emmental ; pain complet.

Dessert : compote pommes-pruneaux sans sucre ajouté, fromage blanc, cannelle.

Le candidat réalise le velouté, le parmentier et la compote. Il présente les adaptations pour Monsieur R., Madame L., Monsieur G., Madame V. et Monsieur N., et une organisation qui permet de préparer le parmentier à l'avance et de le congeler en portions individuelles.

Document 3 – Grammages nets par portion, pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Potiron	150 g	30 %	1,90 € le kg
Pommes de terre (velouté 40 g et parmentier 150 g)	190 g	15 %	1,40 € le kg
Oignons	15 g	10 %	1,80 € le kg
Huile de colza (velouté 3 g et poireaux 3 g)	6 g	sans perte	3,20 € le kg
Filets de cabillaud surgelés	100 g	sans perte	13,90 € le kg
Poireaux	80 g	25 %	2,60 € le kg
Lait demi-écrémé	50 g	sans perte	1,05 € le litre (1 L = 1 kg)
Beurre doux	5 g	sans perte	9,80 € le kg
Emmental râpé	10 g	sans perte	9,90 € le kg
Pain complet	40 g	sans perte	4,60 € le kg
Pommes	100 g	20 %	2,40 € le kg
Pruneaux dénoyautés	20 g	sans perte	9,50 € le kg
Fromage blanc 3 % de matière grasse	100 g	sans perte	2,60 € le kg
Cannelle, muscade, sel, poivre	–	–	forfait 0,90 € pour l'atelier

Quantité brute = quantité nette / (1 – taux de perte).

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Potiron, cru (20044)	20,1	1,05	3,5	1,93	0,1	0,5	0,0025	20,5	0,85	10,7
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	80	2,02	16,2	0,78	0,09	2,2	< 0,0011	14,3	0,78	19,7
Oignon, cru (20034)	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098	25	0,00019	3,9
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0,023	0
Cabillaud, cru (26043)	77,4	18,1	traces	traces	0,57	< 0,2	0,23	4,43	0,49	1
Poireau, cru (20039)	30,4	1,5	4,55	3,9	0,3	1,8	0,05	59	2,1	12
Lait demi-écrémé, pasteurisé (19042)	46,4	3,19	4,9	4,81	1,54	0	0,078	119	0,041	1,6
Beurre à 80% MG minimum, doux (16400)	753	0,64	0,71	0,71	83	0	0,035	19,8	< 0,5	0
Emmental ou emmenthal, râpé (12118)	368	27,6	0,58	traces	28,2	0,042	0,68	977	< 0,25	< 0,5

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Pain complet ou intégral (à la farine T150) (7110)	234	8,66	41,2	2,41	1,7	7,3	1,17	83,2	2	< 2
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037	5,34	0,099	4,6
Pruneau, sans noyau, sec (13042)	229	1,63	55,4	38,1	0,4	5,1	< 0,013	50	0,38	< 0,5
Fromage blanc, nature, 2-3% MG (19646)	75,7	7,28	3,86	3,86	3,23	0,019	0,088	131	< 0,25	< 2
Cannelle, poudre (11025)	243	3,99	27,5	2,17	1,24	53,1	0,025	1000	8,32	3,8
Lentille corail, sèche (20535)	328	27,7	44,9	1,29	0,8	15,4	< 0,13	29	6,3	< 0,5

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. On compte 0,3 g de cannelle par portion ; le sel ajouté et la muscade ne sont pas comptés. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 5 – Enquête réalisée par l'association auprès de ses adhérents (données fictives, février 2028)

Questionnaire de 12 questions envoyé par courrier et par courriel aux 42 foyers adhérents, avec aide au remplissage par téléphone ; 31 réponses.

- 14 foyers citent la constipation comme une gêne fréquente ;
- 11 disent que la personne malade a du mal à éplucher, couper ou ouvrir les emballages ;
- 9 signalent une perte de poids depuis un an ;
- 8 signalent une toux ou des fausses routes pendant les repas ;
- 17 disent que les repas sont désormais préparés par l'aidant seul ;
- 20 souhaitent des recettes faciles, adaptées et qui se congèlent ;
- 12 aidants disent manquer de temps pour cuisiner.

Document 6 – Trois situations qui pourraient se présenter pendant l'atelier

Au bout de 40 minutes, Monsieur G. entre dans une période de blocage et ne peut plus se lever de sa chaise. Une aidante vous demande s'il faut « supprimer la viande » pour que le traitement de son mari marche mieux, parce qu'elle l'a lu sur un forum. Le laboratoire qui commercialise un des traitements propose de financer les prochains ateliers et de fournir des tabliers à son logo.

Document 7 – Repères utiles (données réelles)

- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des féculents complets au moins une fois par jour ; des produits laitiers deux fois par jour ; boire de l'eau à volonté.
- Anses (références nutritionnelles, 2016 et 2021) : apport satisfaisant en fibres de 30 g par jour pour l'adulte ; calcium 950 mg par jour pour l'adulte de 25 ans et plus ; vitamine C 110 mg par jour.
- Les protéines alimentaires peuvent gêner l'absorption de la lévodopa ; l'horaire des prises et une éventuelle répartition des protéines dans la journée relèvent du neurologue, et ne justifient pas de

supprimer les protéines.

- Les troubles de la déglutition exposent aux fausses routes ; l'adaptation des textures est décidée avec l'orthophoniste ou le médecin ; le cadre international IDDSI décrit des niveaux de textures (par exemple, niveau 6 « tendre et en petits morceaux », niveau 5 « haché et humide »).
- Règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) : information sur 14 allergènes, dont le gluten, le lait et le poisson, y compris pour les denrées non préemballées.
- Bonnes pratiques d'hygiène : cuisson à cœur du poisson ; refroidissement rapide des préparations avant congélation ; étiquetage (nom, date) ; décongélation au réfrigérateur.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (11 points)

1. Exploitez le document 5 (taux de réponse et pourcentages) et dégagez trois besoins prioritaires. Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier, mesurables à la fin de la séance. (2 pts)

2. Établissez le bon de commande pour 12 portions (quantités nettes, quantités brutes, unités de commande, coût) ; calculez le coût par portion, vérifiez le respect du budget et identifiez le poste le plus coûteux. (2 pts)

3. Rédigez la fiche technique de l'entrée, du plat et du dessert (ingrédients, matériel adapté aux tremblements, étapes, points critiques). Présentez les adaptations pour Monsieur R., Madame L., Monsieur G., Madame V. et Monsieur N., et l'organisation de la préparation à l'avance avec congélation. (3 pts)

4. Calculez l'apport d'une portion du repas complet en énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer et vitamine C, et la répartition de l'énergie. Commentez au regard des repères, en particulier pour les fibres et pour Monsieur R. ; calculez l'effet d'un enrichissement de sa part (10 g d'emmental et 30 g de fromage blanc en plus dans la purée). (2 pts)

5. Rédigez la check-list logistique (avant, jour J, après) et le planning de préparation de l'atelier, en tenant compte de la fatigue et de la lenteur des gestes des participants. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et participants), avec une pause et des tâches adaptées à chacun (assis, sans couteau pointu). (2 pts)

7. Présentez les méthodes d'animation et les outils (démonstration, binômes malade-aidant, fiche recette imagée en gros caractères, ustensiles adaptés, « faire dire »), ainsi qu'une grille de dégustation simple. (1,5 pt)

8. Présentez les règles d'hygiène (poisson, refroidissement et congélation, étiquetage), la sécurité (brûlures, couteaux, chutes), la gestion des allergènes et trois éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

9. Réalisez les trois préparations ; dressez une assiette adaptée à Madame L. et une assiette standard ; conditionnez deux portions de parmentier pour la congélation. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier (satisfaction, sentiment de capacité, intention de refaire, participation des malades aux gestes) et analysez les trois situations du document 6, avec la réponse que vous donnez à chaque personne. (1 pt)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « On commence à 5 heures, on mange à 9 heures, et encore » : piloter à mi-parcours un projet pour les agents de propreté d'une ville et animer un atelier de collation

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet de synthèse – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2)

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Temps 1 : préparation conseillée 3 h, puis 30 min d'oral blanc · Temps 2 : 3 h · Barème : 20 points pour chaque temps. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E4 (pilotage et bilan d'étape d'un projet), E5.A et E5.B (atelier culinaire, bon de commande, calcul nutritionnel).

Mise en situation – Mise en situation

La ville de Saint-Aubin-sur-Lhers (ville et service fictifs) emploie 64 agents au service de la propreté urbaine. Ils prennent leur poste à 5 h, font une pause de 20 minutes à 9 h et terminent à 12 h. Après plusieurs malaises en fin de matinée, la direction des ressources humaines, le service de prévention et de santé au travail et les représentants du personnel ont lancé en novembre 2027 un projet de huit mois, « Bien démarrer sa tournée ». Vous arrivez en stage à la fin du mois de février 2028, au milieu du projet. La coordinatrice vous confie le bilan d'étape pour le comité de pilotage du 6 mars, puis l'animation de l'atelier de collation du mois de mars.

Temps 1 – Le bilan d'étape et l'ajustement du projet

Document 1 – Le diagnostic de septembre 2027 (données fictives)

Questionnaire anonyme distribué au vestiaire et rempli pendant la pause ; 50 réponses sur 64 agents.

- 31 agents ne mangent rien avant leur prise de poste ;
- 38 achètent leur collation au distributeur automatique du centre technique (viennoiseries, barres chocolatées, sodas) ;
- 22 boivent au moins un soda ou une boisson énergisante par matinée ;
- 27 se disent « très fatigués » en fin de tournée ;
- 19 trouvent le four à micro-ondes du vestiaire sale ou toujours occupé ;
- 29 sont intéressés par un atelier pendant le temps de travail.

Document 2 – Le plan d'action prévu (novembre 2027 à juin 2028)

- **Objectif spécifique 1** : en juin 2028, au moins 50 % des agents participants prennent un petit-déjeuner ou une collation préparée chez eux avant ou pendant la tournée (valeur initiale : 27,8 % des participants).
- **Objectif spécifique 2** : en juin 2028, la part des agents qui boivent un soda ou une boisson énergisante chaque matinée passe de 44 % à 25 % au plus.
- **Actions** : 6 ateliers de collation de 1 h 30 sur le temps de travail (un par mois, 12 places chacun, soit 72 places) ; installation d'une fontaine à eau réfrigérée et distribution d'une gourde à chaque agent ; négociation avec le gestionnaire du distributeur pour introduire des produits plus favorables ; affiches et livret de recettes ; formation de deux agents relais.
- **Objectif opérationnel de participation** : taux de présence d'au moins 80 % des places offertes sur l'ensemble des ateliers.

Document 3 – Le tableau de bord à la fin de février 2028 (4 mois sur 8)

- Ateliers réalisés : 3 sur 6 ; présences : 10, 8 et 7 agents.
- Fontaine à eau installée en décembre ; 64 gourdes distribuées ; relevé du compteur de la fontaine : 1 450 litres en janvier.
- Distributeur : le gestionnaire « étudie la demande » depuis décembre ; aucun changement de l'offre.
- Agents relais : 1 sur 2 formé ; le second est en arrêt.
- Raisons d'absence données par les agents (21 réponses, plusieurs possibles) : atelier placé un lundi de forte charge (12), pas prévenu à temps (9), « pas pour moi » (5), horaire de fin d'atelier qui empiète sur la tournée (7).

Document 4 – Le budget : prévu sur huit mois et réalisé à la fin de février (en euros)

Poste	Prévu (8 mois)	Réalisé (fin février)
Denrées (6 ateliers × 12 portions × 1,70 €)	122,40	64,20
Location de la fontaine à eau (8 mois × 60 €)	480,00	240,00
Gourdes (64 × 4,50 €)	288,00	288,00
Diététicienne (6 ateliers × 3 h × 45 €)	810,00	405,00
Coordination (40 h × 24 €)	960,00	612,00
Impression des affiches et du livret	180,00	210,00

Document 5 – Un premier résultat (données fictives, fin février 2028)

Parmi les 18 agents qui ont participé à au moins un atelier, 5 prenaient un petit-déjeuner ou une collation préparée chez eux en septembre ; ils sont 11 fin février. Parmi les 32 autres agents qui avaient répondu en septembre, 9 le font fin février.

Document 6 – Repères utiles (données réelles)

- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des féculents complets au moins une fois par jour ; limiter les boissons sucrées ; l'eau est la seule boisson indispensable.
- Les horaires de travail atypiques (nuit, très tôt le matin) désorganisent les rythmes des repas ; l'Anses a publié en 2016 une évaluation des risques sanitaires liés au travail de nuit.
- Dans la fonction publique territoriale, les questions de santé et de sécurité au travail sont examinées par la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail du comité social territorial.
- Intervalle de confiance du risque relatif : $\exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d)})$.

Travail à faire – Temps 1

Partie A – Le projet d'intervention – C3.1 (9 points)

1. Calculez le taux de réponse et les pourcentages du document 1. Rappelez le problème central et vérifiez la cohérence des objectifs du document 2 avec le diagnostic. (1,5 pt)
2. Calculez les indicateurs du tableau de bord (taux de présence à mi-parcours, nombre de présences nécessaires sur les trois derniers ateliers pour atteindre l'objectif de 80 %, consommation d'eau par agent et par jour ouvré en janvier, sur 21 jours ouvrés). Analysez les écarts et proposez trois ajustements argumentés du plan d'action. (2,5 pts)
3. Calculez, pour chaque poste du budget, le taux de consommation, puis l'écart entre le réalisé et la moitié du prévu. Analysez les dépassements et proposez une solution pour terminer le projet dans l'enveloppe prévue. (2 pts)

4. Établissez la matrice RACI de cinq tâches de la seconde moitié du projet (ateliers, négociation du distributeur, formation du second relais, communication, évaluation). (1,5 pt)
5. Rédigez l'ordre du jour du comité de pilotage du 6 mars et le relevé de décisions attendu. (1,5 pt)

Partie B – Recherche appliquée – C3.3 (3 points)

6. Calculez, fin février, la proportion d'agents qui prennent un petit-déjeuner ou une collation préparée chez eux chez les participants et chez les autres agents, le risque relatif et son intervalle de confiance à 95 %. Calculez aussi l'évolution chez les participants depuis septembre. Interprétez avec prudence (deux biais au moins). (3 pts)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

7. Organisez une veille sur l'alimentation et les horaires de travail atypiques (sources, outils, fréquence, diffusion aux partenaires du projet). (2 pts)

Partie D – Communication et posture – C3.5 et C3.6 (3 points)

8. Proposez une stratégie pour améliorer l'information des agents sur les ateliers (canaux, relais, messages) et rédigez le message d'invitation à l'atelier de mars. Expliquez comment garantir que la participation reste volontaire et que les résultats restent anonymes vis-à-vis de l'encadrement. (1,5 pt)
9. Rédigez la trame minutée de votre exposé et cinq questions probables du jury avec les éléments de réponse. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale (3 points)

Temps 2 – L'atelier « collation de tournée »

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'atelier de mars a lieu au réfectoire du centre technique, de 9 h 30 à 11 h, juste après la pause, avec 10 agents (8 hommes et 2 femmes, de 24 à 61 ans) ; on prévoit 12 portions (agents, l'agent relais et vous). L'objectif est que chaque agent sache préparer **la veille au soir, en moins de 10 minutes**, une collation complète, transportable dans une boîte, qui tienne au corps jusqu'à midi sans passer par le distributeur.

Document 7 – Le public et les contraintes

- Monsieur F., 48 ans, a un diabète de type 2 traité par comprimés.
- Madame H., 33 ans, est intolérante au lactose (elle supporte les fromages affinés).
- Monsieur O., 24 ans, ne mange pas de porc et dit « avoir toujours faim ».
- Monsieur T., 56 ans, n'a pas de réfrigérateur au vestiaire de son secteur et part avec sa boîte à 4 h 30.
- Matériel : 2 plaques électriques, 1 four à micro-ondes, 1 réfrigérateur, 2 grandes tables, un évier ; pas de four.
- Budget denrées : au plus 1,70 € par portion.

Document 8 – Menu imposé

Porridge froid préparé la veille (flocons d'avoine, lait demi-écrémé, pomme râpée, raisins secs, cannelle) ; tartine de pain complet à l'emmental ; œuf dur ; clémentine.

Le candidat réalise le porridge et les œufs durs, prépare les tartines, et présente une boîte de collation montée. Il présente les adaptations pour Monsieur F., Madame H., Monsieur O. et Monsieur T.

Document 9 – Grammages nets par portion, pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Flocons d'avoine	50 g	sans perte	2,20 € le kg
Lait demi-écrémé UHT	150 g	sans perte	0,99 € le litre (1 L = 1 kg)

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Pommes	80 g	20 %	2,40 € le kg
Raisins secs	15 g	sans perte	6,80 € le kg
Pain complet	50 g	sans perte	4,60 € le kg
Emmental en bloc	20 g	sans perte	10,50 € le kg
Œufs (calibre moyen, 50 g net)	1 œuf	sans perte	0,28 € l'œuf
Clémentines	70 g	25 %	2,90 € le kg
Cannelle, sel	–	–	forfait 0,40 € pour l'atelier

Document 10 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Flocons d'avoine (32140)	369	10,6	57,7	1,04	7,82	11,2	0,011	52	3,8	0
Lait demi-écrémé, UHT (19041)	47,7	3,48	5	4,96	1,56	0	0,088	121	< 0,084	< 2
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037	5,34	0,099	4,6
Raisin sec (13046)	322	3	73,2	70,3	0,9	4,2	0,013	54	1,7	< 0,5
Cannelle, poudre (11025)	243	3,99	27,5	2,17	1,24	53,1	0,025	1000	8,32	3,8
Pain complet ou intégral (à la farine T150) (7110)	234	8,66	41,2	2,41	1,7	7,3	1,17	83,2	2	< 2
Emmental ou emmenthal (12115)	373	27,9	traces	traces	28,8	0	0,61	978	0,15	traces
Oeuf cru (22000)	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31	76,8	1,75	0
Clémentine ou mandarine, chair sans peau, sans pépins, crue (13024)	45,5	0,81	9,17	8,6	< 0,5	1,7	< 0,013	23	0,09	49,2

On calcule avec les poids nets crus (l'œuf dur est compté avec les valeurs de l'œuf cru, 50 g). Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. On compte 0,3 g de cannelle par portion. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 11 – Deux situations qui pourraient se présenter pendant l'atelier

Le chef d'équipe passe la tête par la porte et demande la liste des agents « qui ne mangent rien le matin », pour « les avoir à l'œil ». Un agent arrive avec une canette de boisson énergisante et dit : « Ça, c'est mon petit-déjeuner, et je tiens très bien. »

Travail à faire – Temps 2

Partie 1 – Conception (11 points)

10. Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier, mesurables à la fin de la séance. (1,5 pt)

11. Établissez le bon de commande pour 12 portions et calculez le coût par portion. (2 pts)

12. Rédigez la fiche technique de la collation (étapes, temps de préparation la veille, conservation et transport) et les adaptations pour Monsieur F., Madame H., Monsieur O. et Monsieur T. (3 pts)

13. Calculez l'apport de la collation en énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer et vitamine C, et la répartition de l'énergie ; comparez la collation à l'achat type au distributeur (une viennoiserie de 60 g à 410 kcal pour 100 g et un soda de 33 cl à 10,6 g de sucres pour 100 mL, données fictives) en énergie et en sucres. (2,5 pts)

14. Présentez la check-list logistique de l'atelier. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

15. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et agents). (2 pts)

16. Présentez les méthodes d'animation (démonstration, défi « 10 minutes chrono », comparaison avec le distributeur) et les outils. (1,5 pt)

17. Présentez les règles d'hygiène (œufs, chaîne du froid de la boîte, nettoyage du micro-ondes), la gestion des allergènes et deux éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

18. Réalisez la collation et montez une boîte complète ; présentez une boîte adaptée à Monsieur T. (3 pts)

19. Proposez l'évaluation de l'atelier et analysez les deux situations du document 11. (1 pt)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « On cultive des légumes qu'on ne mange pas » : concevoir et piloter un projet alimentation dans un chantier d'insertion maraîcher

que le jury attend

Le jury évalue la capacité à passer du diagnostic à un plan d'action réaliste : des actions qui combinent plusieurs stratégies (éducation, accès aux produits, environnement de travail, participation), décrites précisément, avec des partenaires engagés, un calendrier calculé, un budget équilibré qui respecte les règles du financeur et une trésorerie anticipée. Il valorise la prise en compte des contraintes du public (temps de travail payé, absence de cuisine, petit budget) et la prudence dans l'interprétation de l'essai. Il pénalise un budget déséquilibré, des honoraires classés en charges de personnel, une subvention qui dépasse le plafond, un chemin critique faux et une conclusion « le panier est efficace » tirée d'un essai sur volontaires.

Partie A – Le projet d'intervention

Question 1 – Diagnostic, objectifs et actions (2 pts)

Calcul posé – Indicateurs du document 2

- Taux de réponse : 21 / 24 × 100 = **87,5 %**.
- Pas de repas le midi au moins 3 jours sur 4 : 12 / 21 = **57,1 %** ; pas de cuisine utilisable : 15 / 21 = **71,4 %** ; jamais cuisiné de légumes frais : 9 / 21 = **42,9 %**.
- Légumes moins d'une fois par jour : 16 / 21 = **76,2 %** ; moins de 40 € par semaine pour se nourrir : 14 / 21 = **66,7 %**.
- Intéressés par un panier à prix réduit : 17 / 21 = **81,0 %** ; par un atelier pendant le temps de travail : 13 / 21 = **61,9 %**.

Le taux de réponse est élevé, car le questionnaire a été passé oralement par une personne connue des salariés ; en contrepartie, le risque de **désirabilité sociale** existe. Avec 21 répondants, on donne aussi les effectifs.

Problème central : les salariés en insertion des Jardins du Pré-Haut ont une alimentation irrégulière et pauvre en légumes (repas de midi sauté par 12 salariés sur 21, légumes moins d'une fois par jour pour 16 sur 21), alors qu'ils produisent eux-mêmes des légumes.

Objectif général : contribuer à améliorer l'alimentation et la santé des salariés en parcours d'insertion du chantier.

Objectifs spécifiques (échéance : fin du cycle, en juin 2028, mesure par le même questionnaire oral) :

- OS1 : au moins 60 % des salariés participants prennent un repas le midi au moins 3 jours sur 4 (contre 42,9 % qui le font au départ, soit 9 sur 21).
- OS2 : au moins 50 % des salariés participants mangent des légumes au moins une fois par jour (contre 23,8 %, soit 5 sur 21).
- OS3 : au moins 75 % des participants savent préparer seuls, avec deux plaques ou un micro-ondes, trois recettes à base de légumes du jardin (mise en situation lors du dernier atelier).

Quatre actions et leurs stratégies

Action	Stratégie	Objectif servi
Cycle de 8 ateliers de cuisine de 1 h 30 sur le temps de travail, avec des recettes réalisables avec deux plaques ou un micro-ondes	Éducation pour la santé (compétences)	OS2, OS3

Action	Stratégie	Objectif servi
Panier solidaire hebdomadaire de légumes du jardin à 1 €, avec une fiche recette	Accès aux produits, environnement	OS2
Aménagement de la salle de pause (boîtes, réfrigérateur partagé, repas collectif du mardi) et allongement de la pause de midi à 45 minutes le mardi	Action sur l'environnement de travail, lien social	OS1
Comité de salariés qui choisit les recettes et teste le livret	Participation, pouvoir d'agir	OS1 à OS3

Exemple – L'atelier de cuisine décrit avec la méthode QQOQCCP

Quoi ? Atelier « Un repas complet avec les légumes du jardin et deux plaques ». **Qui ?** 12 salariés volontaires par atelier ; animation par la diététicienne libérale et l'encadrante technique cuisine ; l'accompagnatrice socioprofessionnelle fait le lien avec les parcours. **Où ?** Cuisine de la salle des fêtes, à 400 m, accessible à pied. **Quand ?** Le mardi de 11 h à 12 h 30, huit fois sur 12 semaines, sur le temps de travail (condition de participation exprimée par les salariés). **Comment ?** Démonstration courte, réalisation en binômes, repas pris ensemble, fiche recette imagée, portion à emporter en boîte. **Combien ?** 12 portions à 2,10 € ; 3 heures de diététicienne et de l'encadrante par atelier (préparation comprise). **Pourquoi ?** OS2 et OS3, et indirectement OS1 par l'habitude d'un repas à midi.

Question 2 – Parties prenantes et RACI (1,5 pt)

Position	Parties prenantes	Attitude à adopter
Pouvoir fort, intérêt fort	Direction de l'association ; financeur de l'appel à projets ; service insertion du département (financeur des postes)	Gérer étroitement : membres du comité de pilotage
Pouvoir fort, intérêt faible	Mairie (prêt de la cuisine) ; fondation d'entreprise	Satisfaire : informer, consulter sur ce qui les concerne
Pouvoir faible, intérêt fort	Salariés en insertion ; encadrants ; bénévoles ; diététicienne ; épicerie sociale	Associer : comité de salariés, réunions d'équipe
Pouvoir faible, intérêt faible	Mission locale ; centre communal d'action sociale ; adhérents des paniers	Surveiller et informer : ils peuvent devenir des relais

Tâche	Stagiaire	Encadrante cuisine	Accompagnatrice	Diététicienne	Direction	Comité de salariés
Dossier d'appel à projets	R	C	C	C	A	I
Conventions de partenariat	R	I	C	C	A	–
Organisation de la cuisine	C	R	I	C	A	C
Animation des ateliers	C	R	I	R	A	C
Paniers solidaires	I	C	R	–	A	C
Évaluation et bilan	R	C	C	C	A	C

Une seule personne est **A** par tâche (la direction), car c'est elle qui engage l'association auprès des financeurs.

Question 3 – Calendrier : réseau PERT et chemin critique (2 pts)

Calcul posé – Dates au plus tôt, au plus tard et marges (en semaines)

Au plus tôt : A 0 → 2 ; B 2 → 3 ; C 3 → 6 ; D 3 → 5 ; E 2 → 6 ; F : début max(6 ; 5) = 6, fin 8 ; G : début max(fin E = 6 ; fin F = 8) = 8, fin 9 ; H 9 → 21 ; I 21 → 24 ; J 9 → 11. **Durée minimale : 24 semaines.**

Au plus tard (de droite à gauche) : I 21 → 24 ; J 22 → 24 ; H 9 → 21 ; G : fin = min(début H ; début J) = min(9 ; 22) = 9, début 8 ; F 6 → 8 ; E 4 → 8 ; D 4 → 6 ; C 3 → 6 ; B : fin = min(début C ; début D) = min(3 ; 4) = 3, début 2 ; A : fin = min(début B ; début E) = min(2 ; 4) = 2, début 0.

Marges : A, B, C, F, G, H, I : **0** ; D : 4 − 3 = **1** ; E : 4 − 2 = **2** ; J : 22 − 9 = **13** semaines.

Chemin critique : **A → B → C → F → G → H → I** (2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 12 + 3 = 24 semaines).

Le dossier (tâche C) se termine au plus tôt à la fin de la semaine 6, ce qui correspond exactement à la date limite du document 3 : la tâche est **critique et sans marge**. Il faut donc commencer la rédaction dès la semaine 3, préparer en parallèle les lettres d'engagement des partenaires (tâche D) et viser un dépôt quelques jours avant la date limite. La tâche J (livret) dispose de 13 semaines de marge : on peut la confier au comité de salariés pendant le cycle, en y intégrant les recettes testées en atelier, sans risque pour le calendrier.

Question 4 – Budget prévisionnel et ratios (2 pts)

Calcul posé – Coûts de personnel

- Encadrante : coût employeur mensuel 2 100 × 1,40 = **2 940 €** ; heures mensuelles 35 × 52 / 12 = **151,67 h** ; coût horaire 2 940 / 151,67 = **19,38 €** ; 60 h × 19,38 = **1 162,80 €**.
- Accompagnatrice : 24 h × 22,40 = **537,60 €**.
- Diététicienne libérale : 8 × 3 h × 45 = **1 080,00 €** ; ce sont des **honoraires** (compte 62), pas des charges de personnel, car elle n'est pas salariée de l'association.

Charges	Montant (€)	Produits	Montant (€)
60 – Achats	**1 137,60**	**74 – Subventions**	**3 900,00**
Denrées (8 × 12 × 2,10)	201,60	Appel à projets « Bien manger dans les parcours d'insertion » (sollicité)	2 500,00
Petit matériel	420,00	Conseil départemental (acquis)	800,00
Boîtes de conservation (24 × 6,50)	156,00	Fondation d'entreprise (sollicité)	600,00
Paniers solidaires, part de la structure (240 × 1,50)	360,00	**Fonds propres de l'association**	**312,00**
61-62 – Services extérieurs et autres services	**1 374,00**		
Honoraires de la diététicienne	1 080,00		
Impression du livret (30 × 4,80)	144,00		
Assurance	90,00		
Déplacements	60,00		
64 – Charges de personnel	**1 700,40**		
Encadrante technique cuisine (60 h)	1 162,80		
Accompagnatrice socioprofessionnelle (24 h)	537,60		
Total des charges monétaires	**4 212,00**	**Total des produits monétaires**	**4 212,00**
86 – Contributions volontaires en nature	**657,60**	**87 – Contributions volontaires en nature**	**657,60**
Cuisine de la salle des fêtes (24 h × 15)	360,00	Mise à disposition par la commune	360,00
Légumes du jardin (96 × 0,60)	57,60	Dons en nature de l'association	57,60
Bénévolat (20 h × 12)	240,00	Bénévolat	240,00
Total	**4 869,60**	**Total**	**4 869,60**

Calcul posé – Montant de la subvention demandée

- Plafond de 60 % des charges monétaires : 0,60 × 4 212,00 = **2 527,20 €**.
- Plafond absolu : **2 500 €**. On retient le plus petit : **2 500 €**, soit 2 500 / 4 212,00 × 100 = **59,4 %** des charges monétaires (règle respectée).
- Fonds propres : 4 212,00 − 2 500 − 800 − 600 = **312,00 €**.

Ratio	Calcul	Résultat
Part de l'appel à projets dans le budget total	2 500 / 4 869,60 × 100	51,3 %
Part des financements publics	(2 500 + 800) / 4 869,60 × 100	67,8 %
Part des coûts humains (64 et honoraires)	(1 700,40 + 1 080) / 4 869,60 × 100	57,1 %
Part des contributions en nature	657,60 / 4 869,60 × 100	13,5 %
Coût total par salarié	4 869,60 / 24	202,90 €

Commentaire : le projet repose surtout sur du temps humain (57,1 %), ce qui est normal pour un projet éducatif. Il est cofinancé, mais il dépend fortement de l'appel à projets (51,3 %) et d'un financement de fondation encore sollicité : il faut prévoir une version réduite si l'un des deux est refusé (par exemple 6 ateliers au lieu de 8). Le coût par salarié (202,90 €) reste modéré pour huit ateliers, des paniers pendant dix semaines et un livret. Le salarié paie 1 € par panier : cette somme entre dans les ventes habituelles de paniers de l'association et n'est pas un produit du projet ; seule la part prise en charge par la structure (1,50 €) est une charge du projet.

Question 5 – Trésorerie et risques (1,5 pt)

Mois	Encaissements	Décaissements	Calcul	Solde fin de mois
Janvier	0	180	400 + 0 − 180	220
Février	800	650	220 + 800 − 650	370
Mars	0	1 050	370 − 1 050	− 680
Avril	1 500	820	− 680 + 1 500 − 820	0
Mai	600	760	0 + 600 − 760	− 160
Juin	0	752	− 160 − 752	− 912

Calcul posé – Vérifications

- Avance de l'appel à projets : 60 % × 2 500 = **1 500 €** en avril ; solde **1 000 €** en octobre.
- Décaissements de juin : 4 212 − (180 + 650 + 1 050 + 820 + 760) = 4 212 − 3 460 = **752 €**.
- Après le versement du solde en octobre : − 912 + 1 000 = **88 €**, soit 400 − 312 : on retrouve bien les fonds propres consommés.

Le budget est équilibré, mais la trésorerie est **négative en mars** (− 680 €), puis **de mai à octobre**, avec un besoin maximal de **912 €** fin juin. Solutions : demander au département de verser sa part dès janvier ; décaler l'achat du petit matériel après la notification d'avril ; demander à la fondation un versement à la signature ; mobiliser la trésorerie générale de l'association, avec l'accord du trésorier, en attendant le solde.

Risque	P × G	Rang	Mesure
R1 – Abandons en cours de cycle	3 × 3 = **9**	1 (ex æquo)	Ateliers sur le temps de travail ; liste d'attente ; portion à emporter ; recettes choisies par le comité de salariés
R2 – Retard de notification	3 × 3 = **9**	1 (ex æquo)	Plan de trésorerie, avance du département, achats échelonnés

Risque	P × G	Rang	Mesure
R5 – Absence de l'encadrante	2 × 3 = **6**	3	Fiches techniques partagées ; la diététicienne peut animer seule ; second encadrant sensibilisé
R3 – Intoxication alimentaire	1 × 4 = **4**	4	Formation à l'hygiène (tâche G), plan de nettoyage, chaîne du froid ; un risque de gravité 4 appelle toujours des mesures
R4 – Mauvaise récolte	2 × 2 = **4**	4	Complément par l'épicerie sociale ; recettes de saison adaptables

Partie B – Recherche appliquée

Question 6 – L'essai de l'an dernier (1,5 pt)

Calcul posé – Risque relatif et intervalle de confiance

- Avec panier : 7 / 10 = **70,0 %** ; sans panier : 3 / 11 = **27,3 %**.
- RR = 0,700 / 0,273 = **2,57**.
- Erreur type de ln RR : √(1/7 − 1/10 + 1/3 − 1/11) = √(0,1429 − 0,1000 + 0,3333 − 0,0909) = √0,2853 = **0,534**.
- ln RR = ln 2,57 = **0,943** ; bornes : exp(0,943 − 1,96 × 0,534) = exp(− 0,104) = **0,90** ; exp(0,943 + 1,047) = exp(1,990) = **7,31**.
- IC 95 % : **[0,90 ; 7,31]**.

Les salariés qui ont reçu le panier sont 2,57 fois plus nombreux, en proportion, à déclarer manger des légumes chaque jour. Mais l'intervalle de confiance **contient 1** : avec 21 personnes, la différence n'est **pas statistiquement significative** et peut être due au hasard. Surtout, l'essai ne prouve pas l'efficacité du panier : les salariés avec panier étaient **volontaires** (ils étaient probablement déjà plus intéressés par les légumes : biais de sélection) ; il n'y a pas de mesure avant ; la consommation est **déclarée** à une personne de la structure (désirabilité sociale) ; les effectifs sont très petits. On parle d'un résultat **encourageant**, qui justifie un nouvel essai mieux construit.

Question 7 – Protocole d'évaluation (1,5 pt)

- **Indicateurs de processus** : nombre d'ateliers réalisés (8 prévus) ; taux de présence (présences / (ateliers × inscrits)), avec une cible de 75 % ; nombre de paniers distribués ; nombre de recettes testées par le comité de salariés.
- **Indicateurs de résultat** : les trois objectifs spécifiques (repas de midi, légumes chaque jour, capacité à préparer trois recettes).
- **Outils et moments** : le même questionnaire oral au début (semaine 9) et à la fin (semaine 21), passé par une personne extérieure à l'encadrement pour limiter la désirabilité sociale ; rappel des légumes mangés la veille (plus précis qu'une fréquence générale) ; grille d'observation lors du dernier atelier.
- **Comparaison** : mesure **avant-après chez les mêmes personnes** ; si les places manquent, tirage au sort des participants des premiers ateliers parmi les volontaires, les autres commençant au cycle suivant (groupe de comparaison sans priver personne).
- **Analyse** : pourcentages avec effectifs, évolution en points, prudence sur la généralisation ; entretiens courts avec cinq salariés pour comprendre les freins.

Partie C – Veille

Question 8 – Veille sur les financements (2 pts)

Élément	Organisation proposée
Sources	Sites de l'agence régionale de santé (appels à projets de prévention), de la préfecture et des services déconcentrés de l'État (alimentation, cohésion sociale), du conseil départemental (insertion), de la caisse d'allocations familiales ; réseau régional des structures d'insertion par l'activité économique ; instance régionale d'éducation et de promotion de la santé ; portails de fondations (avec vérification des conflits d'intérêts)
Outils	Alertes par courriel et abonnement aux lettres d'information ; flux d'actualités ; tableau partagé des appels à projets (financeur, thème, montant, date limite, pièces, statut)
Fréquence	Lecture des alertes chaque semaine ; mise à jour du tableau tous les quinze jours ; point en réunion d'équipe chaque mois ; calendrier annuel des appels récurrents en janvier
Partage	Tableau dans l'espace partagé de l'association ; rappel des dates limites un mois avant ; fiche de synthèse d'une page par appel retenu
Qualité	Toujours dater et sourcer ; vérifier l'éligibilité avant de rédiger ; garder les dossiers déposés comme modèles

Partie D – Communication et posture

Question 9 – Plan de communication et fondation (1,5 pt)

Cible	Objectif	Message	Canal	Quand
Salariés en insertion	S'inscrire et rester dans le cycle	« Cuisiner les légumes qu'on cultive, pendant les heures payées »	Annonce orale en réunion d'équipe, affiche imagée dans la salle de pause, encadrants relais	3 semaines avant le cycle, puis chaque lundi
Encadrants et bénévoles	Soutenir la participation	« Le projet a besoin de vous pour motiver et organiser »	Réunion d'équipe, fiche de présentation	Au lancement
Financeurs et département	Informer, rendre compte	« Un projet qui relie insertion et alimentation »	Point d'étape écrit, invitation au repas final	Mi-parcours et bilan
Adhérents des paniers, commune	Valoriser	« Les jardiniers cuisinent leurs légumes »	Lettre aux adhérents, bulletin municipal	Fin du cycle

La fondation d'une enseigne de distribution : l'intérêt est un cofinancement (600 €) qui sécurise le budget. Les risques sont un **conflit d'intérêts** et une utilisation commerciale du projet (image de l'enseigne, promotion de produits auprès d'un public précaire), contraire à l'indépendance attendue d'une action de santé (chapitre 6). Conditions à poser dans une convention : aucune présence de produits ou de marques dans les ateliers et le livret ; aucune collecte de données sur les salariés ; mention du soutien sur un support institutionnel seulement, validée par l'association ; liberté totale du contenu pédagogique ; possibilité de refuser si ces conditions ne sont pas acceptées.

Question 10 – Exposé et questions du jury (1,5 pt)

Trame de 10 minutes : contexte et demande (1 min) ; diagnostic et chiffres clés (2 min) ; objectifs et actions (2 min) ; calendrier et chemin critique (1 min 30) ; budget, financement et trésorerie (2 min) ; évaluation et limites (1 min) ; conclusion et perspectives (30 s).

Questions probables : Pourquoi les ateliers sont-ils sur le temps de travail ? Pourquoi la diététicienne est-elle au compte 62 ? Que faites-vous si la fondation refuse ? Comment avez-vous calculé le chemin critique ? Que se passe-t-il si le dossier est déposé une semaine en retard ? Comment évitez-vous la stigmatisation des salariés ? Le panier à 1 € n'exclut-il pas les plus pauvres ? Quelle est la limite principale de l'essai de l'an dernier ? Comment mesurez-vous la consommation de légumes ? Comment pérenniser après la subvention ? Quel est le rôle du comité de salariés ? Qu'avez-vous fait vous-même ?

Éléments de réponse pour quatre questions :

- **Temps de travail** : c'est la condition exprimée par les salariés (« si c'est pendant les heures payées, je viens ») ; l'insertion inclut l'acquisition de compétences de vie quotidienne ; cela réduit le risque d'abandon (R1).
- **Fondation qui refuse** : le budget prévoit 312 € de fonds propres ; on réduit à 6 ateliers ou l'on sollicite la caisse d'allocations familiales ou le centre communal d'action sociale ; le chemin critique ne change pas.
- **Dossier en retard** : le dossier est sur le chemin critique et sa date limite coïncide avec la fin au plus tôt de la tâche ; un retard ferait perdre le financement, d'où le démarrage anticipé et le dépôt avant l'échéance.
- **Pérennisation** : le livret, les recettes intégrées aux paniers, deux salariés relais pour les repas du mardi, l'inscription de l'atelier dans le programme d'accompagnement socioprofessionnel et une demande de financement pluriannuel.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages sur les 24 salariés au lieu des 21 répondants ; oublier une dépendance dans le PERT et se tromper de chemin critique ; donner une marge à une tâche critique ; classer les honoraires de la diététicienne en charges de personnel (compte 64) au lieu du compte 62 ; oublier les charges patronales dans le coût horaire ; inscrire les contributions volontaires en nature d'un seul côté du budget ; demander plus que le plafond de 2 500 € ou plus de 60 % des charges monétaires ; oublier que le solde de la subvention n'arrive qu'en octobre et laisser la trésorerie négative ; conclure à un effet certain de l'essai alors que l'intervalle de confiance du risque relatif contient 1.

Corrigé S2 – « Mes mains tremblent, mais je veux encore cuisiner » : un atelier culinaire pour des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches

que le jury attend

Le jury évalue un atelier réellement adapté au public : des tâches possibles avec des tremblements et une lenteur des gestes (travail assis, ustensiles à gros manche, planches antidérapantes, pas de couteau pointu), des textures adaptées aux troubles de la déglutition, des repas riches en fibres et en eau, un rythme qui tient compte de la fatigue. Il vérifie les calculs (bon de commande avec rendement, coût, apports) et la logistique (check-list, préparation à l'avance, congélation en sécurité). Il valorise le respect des limites de rôle : on ne modifie ni un traitement ni un régime prescrit, on oriente vers le neurologue ou l'orthophoniste. Il pénalise un atelier où les aidants font tout, des conseils médicaux donnés à la place des soignants et l'acceptation sans condition d'un financement par un laboratoire.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Besoins et objectifs (2 pts)

Calcul posé – Exploitation du document 5

- Taux de réponse : 31 / 42 × 100 = **73,8 %**.
- Constipation : 14 / 31 = **45,2 %** ; difficultés pour éplucher, couper, ouvrir : 11 / 31 = **35,5 %** ; perte de poids : 9 / 31 = **29,0 %** ; toux ou fausses routes : 8 / 31 = **25,8 %**.
- Repas préparés par l'aidant seul : 17 / 31 = **54,8 %** ; souhait de recettes faciles qui se congèlent : 20 / 31 = **64,5 %** ; aidants qui manquent de temps : 12 / 31 = **38,7 %**.

Trois besoins prioritaires : **garder une place active dans la cuisine** malgré les difficultés motrices (plus de la moitié des repas sont désormais préparés par l'aidant seul) ; **prévenir la constipation et la perte de poids** par des repas riches en fibres, en eau et suffisamment énergétiques ; **gagner du temps** grâce à des recettes simples, faciles à mâcher et à avaler, préparées à l'avance et congelées.

Objectif général : contribuer à préserver l'autonomie, l'état nutritionnel et le plaisir de manger des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et de leurs proches.

Objectifs opérationnels (vérifiés à la fin de la séance) :

- chaque personne malade réalise au moins deux gestes de la recette (laver, mélanger, émietter, monter le parmentier, servir), observés par l'animateur ;
- au moins 8 participants sur 10 citent deux moyens d'augmenter les fibres et l'eau d'un repas (tour de table) ;
- chaque foyer repart avec une portion congelable étiquetée et la fiche recette en gros caractères.

Question 2 – Bon de commande pour 12 portions (2 pts)

Denrée	Net total	Brut total	Commande	Coût (€)
Potiron	12 × 150 = 1 800 g	1 800 / 0,70 = 2 571 g	2,6 kg	2,571 × 1,90 = 4,89
Pommes de terre	12 × 190 = 2 280 g	2 280 / 0,85 = 2 682 g	2,7 kg	2,682 × 1,40 = 3,76
Oignons	180 g	180 / 0,90 = 200 g	200 g	0,200 × 1,80 = 0,36
Huile de colza	72 g	72 g	1 bouteille (entamée)	0,072 × 3,20 = 0,23
Cabillaud surgelé	1 200 g	1 200 g	1,2 kg	1,200 × 13,90 = 16,68
Poireaux	960 g	960 / 0,75 = 1 280 g	1,3 kg	1,280 × 2,60 = 3,33
Lait demi-écrémé	600 g	600 g	1 L (entamé)	0,600 × 1,05 = 0,63
Beurre doux	60 g	60 g	1 plaquette de 125 g	0,060 × 9,80 = 0,59
Emmental râpé	120 g	120 g	1 sachet de 150 g	0,120 × 9,90 = 1,19

Denrée	Net total	Brut total	Commande	Coût (€)
Pain complet	480 g	480 g	1 pain de 500 g	0,480 × 4,60 = 2,21
Pommes	1 200 g	1 200 / 0,80 = 1 500 g	1,5 kg	1,500 × 2,40 = 3,60
Pruneaux dénoyautés	240 g	240 g	1 sachet de 250 g	0,240 × 9,50 = 2,28
Fromage blanc 3 %	1 200 g	1 200 g	1,2 kg	1,200 × 2,60 = 3,12
Épices, sel, poivre	–	–	–	forfait 0,90
Total				**43,77**

Calcul posé – Coût par portion

43,77 / 12 = **3,65 €** par portion, sous le plafond de 3,80 € (marge de 0,15 € par portion, soit 1,80 € pour l'atelier). Le cabillaud est le poste le plus coûteux : 16,68 / 43,77 × 100 = **38,1 %** du coût. Si le budget se resserre, on peut le remplacer par un poisson blanc moins cher (lieu noir, colin) ou réduire le grammage à 90 g en ajoutant un œuf dans la purée.

On calcule le coût sur la quantité **réellement utilisée** (exemple : 60 g de beurre) ; les produits entamés (huile, lait, beurre) restent à l'association pour les ateliers suivants, ce qui est noté dans l'inventaire.

Question 3 – Fiches techniques, adaptations et préparation à l'avance (3 pts)

Matériel adapté : planches à découper antidérapantes (ou torchon humide dessous), épluche-légumes à gros manche, couteaux à bout rond pour les participants (le candidat taille le potiron cru, dur et dangereux), presse-purée ou mixeur plongeant apporté par le candidat, bols lestés ou posés sur un tapis antidérapant, verres à anse, tablier pour chacun, tables à hauteur assise.

Préparation	Étapes	Points critiques
Velouté de potiron	1. Le candidat ouvre et taille le potiron en gros cubes ; les participants épluchent les pommes de terre et l'oignon assis. 2. Faire suer l'oignon dans 36 g d'huile, ajouter potiron et pommes de terre en cubes, couvrir d'eau à hauteur. 3. Cuire 25 minutes à couvert, mixer finement, rectifier la consistance avec de l'eau de cuisson, assaisonner (muscade).	Sécurité de la découpe du potiron ; mixage loin du bord de la table ; servir chaud mais pas brûlant
Parmentier de cabillaud aux poireaux	1. Décongeler le cabillaud au réfrigérateur la veille (ou le cuire directement surgelé à la vapeur douce). 2. Laver les poireaux fendus en quatre (participants), les émincer finement (candidat), les étuver 15 minutes dans 36 g d'huile avec un peu d'eau. 3. Cuire les pommes de terre à l'eau 20 minutes, les écraser avec le lait chaud et le beurre. 4. Pocher le cabillaud 8 minutes dans de l'eau frémissante, l'égoutter, l'émietter à la fourchette en retirant les arêtes (participants). 5. Monter dans un plat : poireaux, poisson, purée, emmental. 6. Gratiner 15 minutes à 200 °C.	Cuisson à cœur du poisson ; recherche des arêtes ; refroidissement rapide de la part à congeler

Préparation	Étapes	Points critiques
Compote pommes-pruneaux	1. Laver, éplucher et couper les pommes (participants avec épluche-légumes et couteau à bout rond). 2. Cuire 15 minutes à couvert avec les pruneaux, un fond d'eau et la cannelle, sans sucre. 3. Écraser ou mixer selon la texture souhaitée. 4. Servir tiède avec 100 g de fromage blanc.	Pas de sucre ajouté ; texture lisse pour Madame L.

Adaptations

Personne	Adaptation	Justification
Monsieur R. (perte de 5 kg)	Enrichir sa part : + 10 g d'emmental et + 30 g de fromage blanc dans la purée ; proposer une collation l'après-midi (fromage blanc et compote) ; petites portions plus fréquentes s'il se fatigue	Perte de poids et fatigue au repas ; besoin d'énergie et de protéines
Madame L. (toux, textures tendres et humides)	Purée lisse et bien nappée ; poisson très finement émietté et mélangé à la purée ; pas de pain (miettes sèches) ou pain de mie sans croûte trempé dans le velouté ; compote mixée lisse ; consistance du velouté et des boissons à vérifier avec son orthophoniste ; manger assise bien droite, petites bouchées, sans parler en mangeant	Les aliments secs, les miettes et les mélanges de textures favorisent les fausses routes ; le niveau de texture est fixé par le soignant, pas par l'animateur
Monsieur G. (lévodopa, blocages)	On ne modifie pas son repas : on lui rappelle de suivre l'horaire de prise fixé par son neurologue ; on prévoit pour lui des tâches assises qu'il peut interrompre ; s'il le souhaite, on lui remet une fiche à montrer à son neurologue sur la répartition des protéines	La répartition des protéines relève d'une prescription ; supprimer les protéines exposerait à la dénutrition
Madame V. (diabète de type 2)	Repas sans sucre ajouté ; dessert pris à la fin du repas ; pain complet ; part de compote de 120 g environ (pommes et pruneaux)	Les sucres du repas viennent des fruits et du lait ; les fibres et la prise au cours du repas limitent l'élévation de la glycémie
Monsieur N. (pas de poisson)	Version aux lentilles corail : 50 g de lentilles sèches cuites 12 minutes avec les poireaux, à la place du cabillaud	Apport protéique et fibres conservés (calcul en question 4)

Préparation à l'avance et congélation : monter deux parmentiers individuels dans des barquettes en aluminium avant gratinage ; les refroidir rapidement (bac d'eau froide avec glaçons, puis réfrigérateur) ; filmer, étiqueter (nom du plat, date de fabrication, allergènes : poisson, lait) ; congeler à − 18 °C ; consommer dans le mois ; décongeler au réfrigérateur la veille, puis réchauffer à cœur au four ou au micro-ondes, couvert. Le velouté et la compote se congèlent aussi en portions dans des boîtes de 250 mL.

Question 4 – Apports nutritionnels d'une portion (2 pts)

Calcul posé – Apports par préparation (valeurs Ciqual 2025, poids nets crus)

- Velouté (potiron 150 g, pomme de terre 40 g, oignon 15 g, huile 3 g) : énergie 150 × 20,1 / 100 + 40 × 80 / 100 + 15 × 39 / 100 + 3 × 900 / 100 = 30,15 + 32,00 + 5,85 + 27,00 = **95,0 kcal** ; protéines **2,55 g** ; fibres **1,88 g** ; vitamine C **24,52 mg**.
- Parmentier et pain (pomme de terre 150 g, cabillaud 100 g, poireau 80 g, lait 50 g, beurre 5 g, emmental 10 g, huile 3 g, pain complet 40 g) : **439,97 kcal** ; protéines **30,18 g** ; glucides **46,96 g** ; lipides **12,37 g** ;

fibres **7,66 g** ; sel **0,85 g** ; calcium **264,55 mg**.

- Dessert (pomme 100 g, pruneaux 20 g, fromage blanc 100 g, cannelle 0,3 g) : **176,23 kcal** ; protéines **7,87 g** ; glucides **26,62 g** dont sucres **22,09 g** ; calcium **149,34 mg**.

Nutriment	Velouté	Parmentier et pain	Dessert	Repas
Énergie (kcal)	95,00	439,97	176,23	**711,2**
Protéines (g)	2,55	30,18	7,87	**40,60**
Glucides (g)	12,67	46,96	26,62	**86,25**
dont sucres (g)	3,93	7,69	22,09	**33,71**
Lipides (g)	3,28	12,37	3,56	**19,21**
Fibres (g)	1,88	7,66	2,60	**12,15**
Sel (g)	0,02	0,85	0,09	**0,96**
Calcium (mg)	40,22	264,55	149,34	**454,1**
Fer (mg)	1,59	4,16	0,20	**5,95**
Vitamine C (mg)	24,52	40,95	4,61	**70,1**

Calcul posé – Répartition de l'énergie et comparaison aux repères

- Protéines : 40,60 × 4 / 711,2 × 100 = **22,8 %** ; lipides : 19,21 × 9 / 711,2 × 100 = **24,3 %** ; glucides : 86,25 × 4 / 711,2 × 100 = **48,5 %** (le reste vient des fibres, comptées à 2 kcal par gramme dans les valeurs Ciqual).
- Sucres ajoutés : **0 g** (les 33,71 g de sucres viennent des fruits, des légumes et du lait).
- Fibres : 12,15 / 30 × 100 = **40,5 %** de l'apport satisfaisant de la journée ; calcium : 454,1 / 950 × 100 = **47,8 %** ; vitamine C : 70,1 / 110 × 100 = **63,7 %**.

Commentaire : le repas est complet (légumes, féculents, poisson, produit laitier, fruit), pauvre en sel (0,96 g) et sans sucre ajouté. Il apporte 40 % des fibres de la journée en un seul repas, grâce aux légumes, au pain complet et aux pruneaux, et beaucoup d'eau (velouté, compote, légumes) : c'est utile contre la constipation, à condition de boire aussi tout au long de la journée. Les protéines (40,6 g) sont élevées pour un repas ; pour Monsieur G., c'est le neurologue qui dit si leur répartition doit être modifiée.

Calcul posé – Enrichissement de la part de Monsieur R. et version de Monsieur N.

- Monsieur R. : + 10 g d'emmental (36,8 kcal ; 2,76 g de protéines ; 97,7 mg de calcium) et + 30 g de fromage blanc (22,71 kcal ; 2,18 g ; 39,3 mg), soit **+ 59,5 kcal**, **+ 4,94 g** de protéines, **+ 137,0 mg** de calcium. Repas enrichi : **770,7 kcal**, **45,54 g** de protéines, **591,1 mg** de calcium, pour un volume presque inchangé, ce qui convient à une personne qui se fatigue en mangeant.
- Monsieur N. : on retire le cabillaud (77,4 kcal ; 18,10 g de protéines) et l'on ajoute 50 g de lentilles corail sèches (164,0 kcal ; 13,85 g de protéines ; 7,70 g de fibres ; 3,15 mg de fer). Repas : **797,8 kcal**, **36,35 g** de protéines, **19,85 g** de fibres, **8,61 mg** de fer. Les protéines restent suffisantes et les fibres augmentent nettement.

Question 5 – Check-list logistique et planning (2 pts)

Moment	Tâches
J − 10	Confirmer la salle (plaque, four, réfrigérateur, tables assises) ; recueillir les allergies, régimes et consignes de texture à l'inscription ; prévenir l'aidant de Madame L. pour obtenir la consigne écrite de l'orthophoniste
J − 3	Courses (bon de commande) ; cabillaud gardé au congélateur ; impression des fiches recettes en police 16, illustrées ; barquettes, film, étiquettes, sacs isothermes

Moment	Tâches
J – 1	Mettre le cabillaud à décongeler au réfrigérateur ; préparer le matériel adapté (planches antidérapantes, épluche-légumes à gros manche, mixeur) ; rappel téléphonique aux participants
Jour J, avant	Arrivée 1 h avant : installation des postes assis, circulation dégagée pour les cannes, affichage des allergènes, eau et verres à anse sur chaque table, fiche d'émargement
Jour J, pendant	Pause de 10 minutes au milieu ; une tâche de remplacement assise prévue pour chacun ; surveillance des plaques et du four par le candidat seul
Après	Nettoyage et désinfection, inventaire des produits entamés, congélation des portions, bilan à chaud, saisie des évaluations, compte rendu au bureau

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté des 3 heures (2 pts)

Horaire	Candidat	Participants
0 h 00 – 0 h 40	Conception finale, mise en place des postes, pesée, découpe du potiron, mise à cuire des pommes de terre du parmentier	–
0 h 40 – 0 h 50 (14 h 00 – 14 h 10)	Accueil, présentation des objectifs, règles (chacun va à son rythme, on peut s'arrêter), tour de table « un plat que j'aime cuisiner »	Arrivée, installation, tablier, lavage des mains
0 h 50 – 1 h 20	Démonstration du velouté, répartition des tâches en binômes malade-aidant	Épluchage des pommes de terre et des pommes, lavage des poireaux, assis
1 h 20 – 1 h 40	Étuvée des poireaux, pochage du poisson, cuisson de la compote	Émiettage du poisson, écrasement de la purée, assaisonnement
1 h 40 – 1 h 50	Pause, boisson	Pause
1 h 50 – 2 h 10	Montage des parmentiers, gratinage, conditionnement des portions à congeler, mixage du velouté et de la compote	Montage des parts individuelles, étiquetage
2 h 10 – 2 h 40 (15 h 30 – 16 h 00)	Dégustation, échange sur les fibres, l'eau et la préparation à l'avance, grille de dégustation, questionnaire de fin	Dégustation, avis, questions, départ avec les portions et la fiche
2 h 40 – 3 h 00	Remise en état, rangement, inventaire, bilan	–

Si un participant se fatigue, il passe à une tâche de goût ou d'étiquetage ; l'aidant n'est pas chargé de « faire à sa place ».

Question 7 – Méthodes, outils et grille de dégustation (1,5 pt)

- **Démonstration** courte de chaque geste, puis pratique en binômes malade-aidant : le malade réalise les gestes possibles, l'aidant aide sans se substituer.
- **Faire dire** : « Comment faites-vous chez vous pour éplucher ? » ; partage d'astuces entre participants (s'asseoir, caler le bol, tenir l'avant-bras sur la table).
- **Fiche recette** en gros caractères, avec photos des étapes et pictogrammes « se congèle », « texture tendre ».
- **Échange** sur les fibres et l'eau à partir des aliments sur la table (pruneaux, pain complet, poireaux), sans exposé.
- **Grille de dégustation** à trois visages (j'aime, moyen, je n'aime pas) pour le goût, la texture (facile à mâcher et à avaler) et l'envie de refaire, remplie à l'oral pour ceux qui écrivent difficilement.

Question 8 – Hygiène, sécurité, allergènes et éco-gestes (1,5 pt)

- **Hygiène** (5 M) : lavage des mains à l'arrivée et après avoir touché le poisson cru ; tablier ; planches distinctes pour le poisson et les fruits ; décongélation au réfrigérateur ; cuisson à cœur du poisson ; refroidissement

rapide des portions à congeler, étiquetage (nom, date, allergènes) ; denrées périssables au réfrigérateur jusqu'à l'utilisation ; transport des portions en sac isotherme.

- **Sécurité** : le candidat seul utilise le four, les plaques et le mixeur ; couteaux à bout rond pour les participants ; sol sec et circulation libre pour les cannes ; boissons tièdes et pas trop pleines ; trousse de secours ; numéro d'urgence affiché.
- **Allergènes** du repas : poisson, lait (beurre, lait, emmental, fromage blanc), gluten (pain) ; affichage à l'entrée ; vérification des allergies à l'inscription.
- **Éco-gestes** : cuisson à couvert ; épluchures au compost ; quantités calculées au plus juste avec les rendements ; restes conditionnés et donnés aux participants le jour même.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (3 pts)

Le jury observe l'organisation du poste, l'hygiène, le respect des quantités, la texture (purée lisse, poisson sans arête, compote lisse pour Madame L.), l'assaisonnement, le dressage dans une assiette creuse facile à saisir et le conditionnement étiqueté des portions congelées.

Question 10 – Évaluation et situations (1 pt)

Évaluation : questionnaire oral de fin (satisfaction de 1 à 4 ; « je me sens capable de refaire ce plat chez moi » de 1 à 4 ; intention de le refaire dans le mois) ; observation par l'animateur du nombre de gestes réalisés par chaque malade ; appel téléphonique trois semaines plus tard (plat refait, portion congelée utilisée).

Situation	Réponse
Blocage de Monsieur G.	Rester calme, ne pas le tirer ni le forcer à se lever ; le laisser assis confortablement, lui proposer de l'eau ; demander à son aidant ce qu'il fait d'habitude (horaire du traitement) ; poursuivre l'atelier en lui laissant une tâche assise s'il le souhaite ; en cas de chute ou de malaise, appeler les secours
« Supprimer la viande »	Expliquer avec bienveillance qu'il ne faut pas supprimer les protéines, car le risque de dénutrition est réel ; dire que l'horaire des comprimés et une éventuelle répartition des protéines dans la journée se décident avec le neurologue ; l'inviter à poser la question à la prochaine consultation, avec la fiche remise
Financement par un laboratoire	Remercier et transmettre la proposition au bureau ; signaler le conflit d'intérêts (lien avec la prescription des traitements) ; refuser les tabliers à logo et toute présence de marque dans l'atelier ; si l'association accepte un don, il doit être encadré par une convention qui garantit son indépendance et rendu public ; diversifier les financements (conférence des financeurs, caisse de retraite, mutuelle)

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages sur les 42 adhérents au lieu des 31 répondants ; oublier le rendement des légumes et du poisson dans le bon de commande ; dépasser le budget de 3,80 € par portion ; modifier soi-même le repas de Monsieur G. (lévodopa) ou supprimer ses protéines, alors que l'horaire des prises relève de son neurologue ; proposer des gestes fins (émincer, décortiquer) sans ustensile adapté ; supprimer la viande pour tout le groupe sur la demande d'une seule personne ; accepter le financement d'un laboratoire sans règles d'indépendance ; faire à la place des participants au lieu de les aider à faire seuls.

Corrigé S3 – « On commence à 5 heures, on mange à 9 heures, et encore » : piloter à mi-parcours un projet pour les agents de propreté d'une ville et animer un atelier de collation

que le jury attend

Au temps 1, le jury évalue la capacité à **piloter** : calculer les indicateurs du tableau de bord, comparer le réalisé au prévu, expliquer les écarts et proposer des ajustements concrets, en gardant le projet dans son enveloppe. Il valorise l'analyse des causes d'absence (jour, horaire, information) plutôt qu'un reproche aux agents, la protection de l'anonymat vis-à-vis de l'encadrement et la prudence dans l'interprétation d'un premier résultat. Au temps 2, il évalue une collation réaliste (préparée la veille en moins de 10 minutes, transportable, sûre sans réfrigérateur), des calculs justes et une animation qui respecte les choix des agents.

Temps 1 – Le bilan d'étape et l'ajustement du projet

Question 1 – Diagnostic et cohérence des objectifs (1,5 pt)

Calcul posé – Exploitation du document 1

- Taux de réponse : 50 / 64 × 100 = **78,1 %**.
- Rien avant la prise de poste : 31 / 50 = **62,0 %** ; collation au distributeur : 38 / 50 = **76,0 %** ; soda ou boisson énergisante chaque matinée : 22 / 50 = **44,0 %**.
- Très fatigués en fin de tournée : 27 / 50 = **54,0 %** ; micro-ondes sale ou occupé : 19 / 50 = **38,0 %** ; intéressés par un atelier : 29 / 50 = **58,0 %**.

Problème central : **un rythme alimentaire désorganisé par la prise de poste à 5 h**, avec une matinée de travail physique sans repas pour la majorité des agents et une collation achetée au distributeur, riche en sucres, associée à une fatigue importante en fin de tournée.

Les objectifs sont cohérents avec le diagnostic : l'OS1 répond au défaut de petit-déjeuner et à la dépendance au distributeur ; l'OS2 reprend la valeur initiale du diagnostic (44 %). Deux remarques : la valeur initiale de l'OS1 (27,8 %) porte sur les **participants**, alors que l'OS2 porte sur **tous les agents** : il faut le préciser et mesurer les deux de la même façon ; la cause « micro-ondes sale ou occupé » (38,0 %) n'a pas d'action correspondante dans le plan.

Question 2 – Tableau de bord et ajustements (2,5 pts)

Calcul posé – Indicateurs à mi-parcours

- Taux de présence : (10 + 8 + 7) / (3 × 12) = 25 / 36 × 100 = **69,4 %** (cible : 80 %).
- Présences nécessaires sur l'ensemble du cycle : 0,80 × 72 = 57,6, soit **58** ; il en faut encore 58 − 25 = **33** sur les 36 places restantes, soit 33 / 36 × 100 = **91,7 %** de présence sur les trois derniers ateliers.
- Eau consommée en janvier : 1 450 / (64 × 21) = 1 450 / 1 344 = **1,08 L** par agent et par jour ouvré.

Indicateur	Prévu	Réalisé	Analyse
Ateliers	3 sur 6	3 sur 6	Conforme
Présence	≥ 80 %	69,4 %	En retard ; la cible de 80 % sur le cycle exigerait 91,7 % de présence d'ici juin, ce qui est peu réaliste sans changement
Fontaine et gourdes	Installées	Installées, 1,08 L par agent et par jour	Bonne appropriation, à suivre en été
Distributeur	Offre modifiée	Aucun changement	Blocage ; la négociation doit remonter à la direction

Indicateur	Prévu	Réalisé	Analyse
Agents relais	2 formés	1 formé	Retard lié à un arrêt

Les raisons d'absence (21 réponses) montrent un problème d'**organisation**, pas de motivation : le lundi de forte charge (12 réponses sur 21, 57,1 %), l'information tardive (9, 42,9 %) et l'horaire qui empiète sur la tournée (7, 33,3 %) l'emportent nettement sur le désintérêt (5, 23,8 %).

Trois ajustements :

1. **Déplacer les ateliers** au jour le plus calme de la semaine, en accord avec les chefs d'équipe, et les terminer à 11 h, avec un temps de trajet compté dans le temps de travail.
2. **Informer plus tôt et autrement** : inscription au planning hebdomadaire deux semaines avant, message oral aux prises de poste par l'agent relais, rappel la veille.
3. **Ajuster la cible ou l'offre** : soit ajouter un 7e atelier (12 places de plus), soit présenter au comité de pilotage une cible révisée et justifiée ; ajouter une action sur le micro-ondes (nettoyage planifié, deuxième appareil) qui répond à une cause du diagnostic.

Question 3 – Suivi du budget (2 pts)

Poste	Prévu (8 mois)	Moitié du prévu	Réalisé	Consommation	Écart à la moitié
Denrées	122,40	61,20	64,20	52,5 %	+ 3,00
Location de la fontaine	480,00	240,00	240,00	50,0 %	0,00
Gourdes	288,00	144,00	288,00	100,0 %	+ 144,00
Diététicienne	810,00	405,00	405,00	50,0 %	0,00
Coordination	960,00	480,00	612,00	63,7 %	+ 132,00
Impression	180,00	90,00	210,00	116,7 %	+ 120,00
Total	**2 840,40**	**1 420,20**	**1 819,20**	**64,0 %**	**+ 399,00**

Calcul posé – Exemples de calculs

- Consommation de la coordination : 612,00 / 960,00 × 100 = **63,7 %** ; heures réalisées : 612 / 24 = **25,5 h** contre 20 h attendues à mi-parcours, soit (25,5 − 20) / 20 × 100 = **+ 27,5 %**.
- Impression : 210,00 / 180,00 × 100 = **116,7 %** : le poste est déjà dépassé de 30,00 €.
- Reste disponible : 2 840,40 − 1 819,20 = **1 021,20 €**.

Analyse : l'écart total (+ 399 €) n'est pas inquiétant en soi, car les gourdes (+ 144 €) sont un achat unique prévu au début. Les vrais dépassements sont l'**impression** (+ 30 € sur le total du poste, déjà consommé) et la **coordination** (5,5 h de plus que prévu, liées au lancement et aux relances du distributeur).

Solution pour finir dans l'enveloppe : les dépenses incompressibles de la seconde moitié sont les denrées (61,20 €), la fontaine (240 €) et la diététicienne (405 €), soit 706,20 €. Il reste 1 021,20 − 706,20 = **315,00 €** pour la coordination, soit 315 / 24 = **13,1 heures** au lieu de 14,5. On confie donc à l'agent relais une partie des rappels, on fait imprimer le livret par le service de reprographie de la ville (sans coût pour le projet) et l'on fixe un plafond d'heures de coordination validé par le comité de pilotage.

Question 4 – Matrice RACI de la seconde moitié (1,5 pt)

Tâche	Stagiaire	Coordinatrice	Diététicienne	Service de prévention et de santé au travail	DRH	Agents relais
Ateliers 4 à 6	R	A	R	C	I	C
Négociation avec le gestionnaire du distributeur	C	R	C	C	A	I

Tâche	Stagiaire	Coordinatrice	Diététicienne	Service de prévention et de santé au travail	DRH	Agents relais
Formation du second agent relais	R	A	C	C	I	I
Communication auprès des agents	R	A	I	I	I	R
Évaluation finale	R	A	C	C	I	C

Question 5 – Ordre du jour et relevé de décisions (1,5 pt)

Ordre du jour du comité de pilotage du 6 mars 2028 (1 h 30) : 1. Rappel des objectifs et du calendrier (5 min). 2. Tableau de bord : ateliers, présence, fontaine, distributeur, relais (20 min). 3. Premiers résultats et leurs limites (10 min). 4. Budget : réalisé, dépassements, reste à engager (15 min). 5. Propositions d'ajustement et décisions (30 min). 6. Communication et calendrier des trois derniers ateliers (5 min). 7. Questions diverses et date du comité de juin (5 min).

Relevé de décisions attendu : nouveau jour et nouvel horaire des ateliers, validés avec les chefs d'équipe ; cible de présence maintenue avec un 7e atelier, ou révisée ; plafond de 13 heures de coordination jusqu'en juin ; impression du livret par la reprographie ; lettre de la DRH au gestionnaire du distributeur avec une date de réponse ; plan de nettoyage du micro-ondes ; date de formation du second relais. Chaque décision a un responsable et une échéance.

Temps 1 – Partie B – Recherche appliquée

Question 6 – Premier résultat (3 pts)

Calcul posé – Comparaison des participants et des autres agents

- Participants : 11 / 18 = **61,1 %** ; autres agents : 9 / 32 = **28,1 %**.
- RR = 0,611 / 0,281 = **2,17**.
- Erreur type de ln RR : √(1/11 − 1/18 + 1/9 − 1/32) = √(0,0909 − 0,0556 + 0,1111 − 0,0313) = √0,1152 = **0,339**.
- ln 2,17 = **0,776** ; bornes : exp(0,776 − 0,665) = exp(0,111) = **1,12** ; exp(0,776 + 0,665) = exp(1,441) = **4,23**. IC 95 % : **[1,12 ; 4,23]**.
- Évolution chez les participants : de 5 / 18 = **27,8 %** à 11 / 18 = **61,1 %**, soit **+ 33,3 points**.

L'intervalle de confiance ne contient pas 1 : la différence entre participants et autres agents est **statistiquement significative**. La progression chez les participants est nette et dépasse déjà la cible de l'OS1 (50 %). L'interprétation reste prudente : les participants sont **volontaires** et étaient peut-être déjà plus motivés (biais de sélection, même si leur valeur de départ, 27,8 %, n'était pas plus élevée que celle des autres) ; les réponses sont **déclarées** à des personnes du projet (désirabilité sociale) ; les effectifs sont petits ; la fontaine et les gourdes ont touché tous les agents, ce qui brouille la comparaison ; on ne sait pas si le changement durera. On parle d'un **résultat encourageant à confirmer** en juin, avec la même question et une passation anonyme.

Temps 1 – Partie C – Veille

Question 7 – Veille sur l'alimentation et les horaires atypiques (2 pts)

- **Sources** : Anses (avis et rapports, dont l'évaluation de 2016 sur le travail de nuit), Santé publique France, Institut national de recherche et de sécurité (dossiers sur les horaires atypiques), Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, Haute Autorité de santé, revues de santé au travail ; textes de la fonction publique territoriale sur la santé au travail.
- **Outils** : alertes par courriel, abonnement aux lettres d'information, bases bibliographiques avec mots-clés (« shift work », « early morning work », « meal timing »), tableau de veille partagé.
- **Fréquence** : alertes lues chaque semaine ; synthèse mensuelle d'une page.

- **Diffusion** : synthèse transmise à la coordinatrice et au service de prévention et de santé au travail ; point en comité de pilotage ; information des représentants du personnel ; chaque document daté et sourcé.

Temps 1 – Partie D – Communication et posture

Question 8 – Information des agents, volontariat et anonymat (1,5 pt)

- **Canaux et relais** : annonce orale à la prise de poste par l'agent relais et les chefs d'équipe ; affiche imagée au vestiaire et près de la fontaine ; inscription au planning ; message court sur le téléphone professionnel la veille.
- **Message d'invitation** : « Mardi 14 mars, de 9 h 30 à 11 h, au réfectoire : on prépare ensemble une collation qui tient jusqu'à midi, prête la veille en 10 minutes. Sur le temps de travail. Inscription auprès de votre agent relais. Les agents des ateliers précédents en parlent mieux que nous ! »
- **Volontariat et anonymat** : l'atelier reste facultatif et ne figure dans aucune évaluation individuelle ; la liste des présents sert seulement au calcul de la présence et n'est pas transmise à l'encadrement ; les questionnaires sont anonymes et analysés par la diététicienne ou la stagiaire ; les résultats sont présentés de façon agrégée, jamais par équipe de moins de cinq agents ; ces règles sont écrites et présentées en comité de pilotage, en lien avec la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail.

Question 9 – Exposé et questions du jury (1,5 pt)

Trame : contexte et diagnostic (2 min) ; plan d'action initial (1 min 30) ; tableau de bord et écarts (2 min) ; budget (1 min 30) ; premier résultat et limites (1 min 30) ; ajustements décidés (1 min) ; conclusion (30 s).

- *Pourquoi la présence est-elle faible ?* Organisation (jour, horaire, information) plutôt que désintérêt, d'après 21 réponses ; ajustements proposés.
- *La cible de 80 % est-elle encore atteignable ?* Seulement avec 91,7 % de présence ou un atelier de plus ; sinon, cible révisée et justifiée devant le comité.
- *Le résultat de février prouve-t-il l'efficacité ?* Non : différence significative, mais volontaires, déclaratif, petit effectif.
- *Pourquoi le budget dépasse-t-il de 399 € ?* Surtout l'achat unique des gourdes ; vrais dépassements : impression et coordination, compensés par un plafond d'heures et la reprographie.
- *Comment protégez-vous les agents ?* Volontariat, anonymat, résultats agrégés, aucune liste transmise à l'encadrement.

Temps 2 – L'atelier « collation de tournée »

Question 10 – Objectifs (1,5 pt)

Objectif général : contribuer à améliorer le rythme alimentaire et la vigilance des agents de propreté pendant leur tournée. **Objectifs opérationnels** (fin de séance) : chaque agent prépare seul un porridge froid en moins de 10 minutes (chronométré) ; chaque agent monte une boîte de collation complète comprenant un féculent, un produit laitier ou un œuf, et un fruit ; au moins 8 agents sur 10 citent deux règles pour transporter une boîte en sécurité sans réfrigérateur.

Question 11 – Bon de commande pour 12 portions (2 pts)

Denrée	Net total	Brut total	Commande	Coût (€)
Flocons d'avoine	600 g	600 g	1 paquet de 1 kg	0,600 × 2,20 = 1,32
Lait demi-écrémé UHT	1 800 g	1 800 g	2 L	1,800 × 0,99 = 1,78
Pommes	960 g	960 / 0,80 = 1 200 g	1,2 kg	1,200 × 2,40 = 2,88
Raisins secs	180 g	180 g	1 sachet de 250 g	0,180 × 6,80 = 1,22
Pain complet	600 g	600 g	2 pains de 300 g	0,600 × 4,60 = 2,76
Emmental en bloc	240 g	240 g	250 g	0,240 × 10,50 = 2,52
Œufs	12	12	2 boîtes de 6	12 × 0,28 = 3,36
Clémentines	840 g	840 / 0,75 = 1 120 g	1,2 kg	1,120 × 2,90 = 3,25
Cannelle, sel	–	–	–	0,40

Denrée	Net total	Brut total	Commande	Coût (€)
Total				**19,49**

Coût par portion : 19,49 / 12 = **1,62 €**, sous le plafond de 1,70 € (marge de 0,08 €).

Question 12 – Fiche technique et adaptations (3 pts)

Étape (la veille au soir)	Temps
Dans une boîte hermétique de 500 mL : 50 g de flocons, 150 g de lait, une pincée de cannelle ; mélanger	2 min
Râper 80 g de pomme avec la peau, l'ajouter avec 15 g de raisins secs ; fermer, réfrigérer	3 min
Préparer la tartine (50 g de pain, 20 g d'emmental en lamelles) dans un papier ou une boîte	2 min
Œuf dur cuit à l'avance (10 minutes dans l'eau bouillante, refroidi, gardé dans sa coquille au réfrigérateur, 2 à 3 jours au plus) ; clémentine	1 min
Le matin : boîte dans un sac isotherme avec un pain de glace ; collation consommée à la pause de 9 h	–

Points critiques : la boîte au lait reste au froid (sac isotherme et pain de glace) ; œuf dur gardé entier ; lavage des mains avant de manger, avec le point d'eau du vestiaire ou une lingette.

Personne	Adaptation
Monsieur F. (diabète de type 2)	Garder le porridge (féculent riche en fibres) ; supprimer les raisins secs ou les réduire à 5 g, la pomme suffit à donner du goût ; tartine et œuf conservés ; collation prise à heure régulière
Madame H. (intolérance au lactose)	Porridge au lait sans lactose ou à une boisson au soja enrichie en calcium ; emmental conservé (fromage affiné, presque sans lactose)
Monsieur O. (pas de porc, faim)	Le menu ne contient pas de porc ; portion augmentée : deux œufs, 75 g de pain, 70 g de flocons
Monsieur T. (pas de réfrigérateur, départ à 4 h 30)	Sac isotherme avec une bouteille d'eau congelée, qui sert aussi de boisson ; porridge préparé à l'eau ou avec une compote sans sucre ajouté au lieu du lait, ou remplacé par un sachet de flocons et un fruit ; tartine à l'emmental (fromage à pâte dure, qui supporte mieux quelques heures hors du froid) ; œuf dur dans sa coquille ; consommation à 9 h au plus tard

Question 13 – Apports nutritionnels et comparaison au distributeur (2,5 pts)

Nutriment	Porridge	Tartine, œuf, clémentine	Collation
Énergie (kcal)	348,28	293,45	**641,7**
Protéines (g)	11,18	16,88	**28,06**
Glucides (g)	56,69	27,05	**83,74**
dont sucres (g)	26,99	7,25	**34,25**
Lipides (g)	6,59	11,52	**18,11**
Fibres (g)	7,51	4,84	**12,35**
Sel (g)	0,14	0,86	**1,00**
Calcium (mg)	222,87	291,70	**514,6**
Fer (mg)	2,26	1,97	**4,23**
Vitamine C (mg)	3,69	34,44	**38,1**

Calcul posé – Exemples de calculs et répartition de l'énergie

- Porridge, énergie : 50 × 369 / 100 + 150 × 47,7 / 100 + 80 × 54 / 100 + 15 × 322 / 100 + 0,3 × 243 / 100 = 184,50 + 71,55 + 43,20 + 48,30 + 0,73 = **348,28 kcal**.
- Tartine, œuf, clémentine : 50 × 234 / 100 + 20 × 373 / 100 + 50 × 140 / 100 + 70 × 45,5 / 100 = 117,00 + 74,60 + 70,00 + 31,85 = **293,45 kcal**.
- Protéines : 28,06 × 4 / 641,7 × 100 = **17,5 %** ; lipides : 18,11 × 9 / 641,7 × 100 = **25,4 %** ; glucides : 83,74 × 4 / 641,7 × 100 = **52,2 %**.
- Achat au distributeur : viennoiserie 60 × 410 / 100 = **246 kcal** ; soda 330 × 10,6 / 100 = **35,0 g** de sucres, soit 35,0 × 4 = **140 kcal** ; total **386 kcal**.

Commentaire : la collation apporte environ 640 kcal, soit 641,7 / 386 = **1,66 fois** l'énergie de l'achat au distributeur, mais avec 28 g de protéines, 12 g de fibres et un demi-apport de calcium : elle « tient au corps » jusqu'à midi, ce que demandent les agents. Ses 34 g de sucres viennent des fruits, des fruits secs et du lait (aucun sucre ajouté), alors que le soda seul apporte 35 g de sucres ajoutés, soit plus que la limite de l'OMS pour une journée (moins de 10 % de l'énergie, environ 50 g pour 2 000 kcal). Pour des agents qui ne mangent rien avant 5 h et font un travail physique, une collation de cette taille à 9 h est adaptée ; elle remplace le petit-déjeuner et ne s'y ajoute pas.

Question 14 – Check-list logistique (2 pts)

Moment	Tâches
J – 7	Réservation du réfectoire ; liste des inscrits, allergies et régimes ; commande des boîtes hermétiques et des sacs isothermes de démonstration
J – 2	Courses selon le bon de commande ; impression de la fiche « 10 minutes chrono » illustrée ; chronomètre ; étiquettes
J – 1	Cuisson des 12 œufs durs, refroidissement, réfrigération ; préparation d'un porridge témoin de la veille pour la dégustation ; rappel aux agents par le relais
Jour J	Installation 45 minutes avant ; postes avec planche, râpe, balance, boîtes ; affichage des allergènes ; nettoyage préalable du micro-ondes
Après	Nettoyage, inventaire, restes distribués aux agents, questionnaires, compte rendu à la coordinatrice

Question 15 – Déroulé minuté des 3 heures (2 pts)

Horaire	Candidat	Agents
0 h 00 – 0 h 45	Mise en place des postes, pesées, contrôle des œufs durs et du porridge témoin	–
0 h 45 – 0 h 55 (9 h 30)	Accueil, objectifs, tour de table « ce que je mange pendant ma tournée »	Installation, lavage des mains
0 h 55 – 1 h 10	Comparaison collation et distributeur avec les emballages et les calculs (sucres en morceaux)	Échange, questions
1 h 10 – 1 h 35	Démonstration, puis défi « 10 minutes chrono »	Chaque agent prépare son porridge, sa tartine et sa boîte
1 h 35 – 2 h 15 (11 h 00)	Dégustation du porridge témoin, boîte adaptée à Monsieur T., questionnaire de fin	Dégustation, avis, départ avec la boîte et la fiche
2 h 15 – 3 h 00	Remise en état, inventaire, bilan	–

Question 16 – Méthodes et outils (1,5 pt)

Démonstration courte puis pratique individuelle ; défi chronométré, qui montre que la préparation tient en moins de 10 minutes ; comparaison concrète avec les produits du distributeur (sucres représentés en morceaux, prix comparés : 1,62 € pour la collation complète) ; échanges entre agents (« qu'est-ce qui marcherait dans ta

tournée ? ») ; fiche recette illustrée au format carte, à garder dans le vestiaire ; trois variantes (compote, banane, fromage blanc).

Question 17 – Hygiène, allergènes, éco-gestes (1,5 pt)

- **Hygiène** : œufs durs cuits la veille, refroidis rapidement, gardés au réfrigérateur dans leur coquille ; porridge au lait conservé au froid jusqu'à la consommation (sac isotherme et pain de glace) ; boîtes lavées chaque jour ; nettoyage quotidien du micro-ondes affiché au vestiaire ; lavage des mains avant la collation.
- **Allergènes** : gluten (avoine, pain), lait (lait, emmental), œuf ; affichage et variantes (boisson au soja enrichie, pain sans gluten si besoin).
- **Éco-gestes** : boîtes et gourdes réutilisables au lieu des emballages du distributeur ; épluchures et trognons au compost du centre technique.

Question 18 – Réalisation (3 pts)

Le jury observe la rapidité et la propreté de la préparation, le respect des grammages, la cuisson des œufs, la présentation d'une boîte complète et étiquetée, et la boîte adaptée à Monsieur T. (sans lait, sac isotherme et bouteille congelée).

Question 19 – Évaluation et situations (1 pt)

Évaluation : questionnaire anonyme de fin (satisfaction ; « je peux le refaire » ; intention de préparer une collation la semaine suivante) ; temps de préparation mesuré pendant le défi ; question posée trois semaines plus tard à l'atelier suivant (collations préparées dans la semaine).

Situation	Réponse
Le chef d'équipe demande la liste	Refuser poliment : les réponses sont anonymes et l'atelier est volontaire ; proposer de lui transmettre les résultats agrégés présentés en comité de pilotage ; en informer la coordinatrice
« La boisson énergisante, c'est mon petit-déjeuner »	Ne pas juger ; l'inviter à goûter et à comparer : énergie, sucres et caféine, tenue jusqu'à midi ; l'inviter à essayer une collation une semaine et à observer sa fatigue en fin de tournée ; le choix lui appartient

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages sur les 64 agents au lieu des 50 répondants ; calculer le taux de réalisation du budget sans le comparer à l'avancement du projet ; confondre un écart favorable et un écart défavorable ; conclure à l'efficacité de l'atelier sans tenir compte des agents qui n'y sont pas venus ; oublier l'heure très matinale de la collation et proposer un plat long à préparer ; dépasser le budget de 1,70 € par portion ; transmettre au chef d'équipe la liste des participants ; juger un agent qui boit une boisson énergisante au lieu de l'inviter à comparer.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Ce que je sais faire	Sujet	Acquis	En cours	À retravailler
C3.1	Construire un plan d'action avec le QQOQCCP et répartir les rôles avec une matrice RACI	S1, S3			
C3.1	Construire un PERT, trouver le chemin critique et calculer les marges	S1			
C3.1	Calculer un coût horaire chargé et construire un budget équilibré avec les bons comptes, y compris les comptes 86 et 87	S1, S3			
C3.1	Appliquer les règles d'un appel à projets (plafond, taux, calendrier de versement) et construire un plan de trésorerie	S1			
C3.1	Piloter avec un tableau de bord : taux de présence, taux de réalisation du budget, écarts, décision	S3			
C3.1	Construire une matrice des risques et proposer des mesures de prévention	S1, S3			
C3.2	Établir un bon de commande avec quantités brutes et nettes et vérifier un budget par portion	S2, S3			
C3.2	Calculer des apports avec la table Ciqual 2025 et la répartition de l'énergie ; adapter une recette à un besoin individuel	S2, S3			
C3.2	Adapter les gestes et le matériel à des personnes qui tremblent ou qui travaillent très tôt	S2, S3			
C3.2	Organiser le déroulé d'un atelier minute par minute et respecter l'hygiène	S2, S3			
C3.3	Calculer un risque relatif et son intervalle de confiance pour évaluer un essai	S1, S3			
C3.4	Organiser une veille datée sur les financements et sur la santé au travail	S1, S3			
C3.5	Construire un plan de communication adapté à chaque public et une trame d'exposé de 10 minutes	S1, S3			
C3.6	Respecter la confidentialité et garder son indépendance face à un financeur privé	S2, S3			

Modèles officiels utilisés : structure des sujets U62 (2002-2014) et E5.B (2021-2024) pour le bon de commande, la fiche technique et l'organisation ; BTS blanc CNED E5B pour le calcul nutritionnel ; texte de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024) pour la répartition des compétences entre les deux temps.

DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE

CHAPITRE 9

Démarche de projet (3) : évaluation et valorisation

Mots-clés : Démarche de projet (3), Évaluer, Interpréter, Valoriser, Pérenniser

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 9 · Démarche de projet (3) : évaluation et valorisation · version normale

1 COURS

Mise en page normale · 93 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 96

2 FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 6 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 97 à 102

3 CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 127 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 103 à 229

4 ANNALES E5

Mise en page normale · 40 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 230 à 269

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 · Cours **4**

9.1 Compétences mobilisées 6
9.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6
9.3 Cours 8
9.4 Approfondissements 72
9.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 78
9.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 79
9.7 L'essentiel à retenir 83
9.8 Entraînement 84
9.9 Glossaire 94
9.10 Renvois bibliographiques par notion 95
9.12 Bibliographie numérotée 96

2 · Fiche de révision et fiches-outils **97**

Fiche de révision du chapitre 9 99
1. Les définitions à savoir 99
2. Les formules 99
3. Interpréter en 4 temps 100
4. Les limites classiques 100
5. Valoriser selon le destinataire 100
6. Les pièges 100
7. Auto-test 100
8. Flashcards 100
Compléments du chapitre enrichi 101
Fiches-outils du chapitre 9 101
O9.1 – Plan d'évaluation 101
O9.2 – Questionnaire de satisfaction accessible 101
O9.3 – Grille d'observation des compétences 102
O9.4 – Analyse avant / après 102
O9.5 – Grille des 6 critères 102
O9.6 – Plan de valorisation 102

3 · Cahier d'exercices **103**

Cahier d'exercices – Chapitre 9 106
Partie 1 – Évaluer : finalités, moments, critères 108
Partie 2 – Les indicateurs et le plan d'évaluation 123
Partie 3 – Les méthodes et les outils de recueil 139
Partie 4 – Les calculs d'évaluation 154
Partie 5 – Interpréter et juger 166
Partie 6 – L'évaluation qualitative 182
Partie 7 – Valoriser et rendre compte 196
Partie 8 – Décider, transférer et s'entraîner sur un cas complet 210
Bilan : grille d'auto-évaluation 229

4 · Annales E5 ..... **230**

Cahier d'annales E5 – chapitre 9 232
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 234
Partie II – Les corrigés détaillés 249
Grille d'auto-évaluation 268

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS

CHAPITRE

09

Démarche de projet (3) : évaluation et valorisation

Démarche de projet (3) | Évaluer | Interpréter | Valoriser | Pérenniser

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

9.1 Compétences mobilisées ... 6
9.2 Croisement référentiel × précisions × indications ... 6
9.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 ... 7
9.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED ... 7
9.3 Cours ... 8
9.3.1 Qu'est-ce qu'évaluer ? ... 8
9.3.2 Construire les indicateurs ... 15
9.3.3 Choisir les méthodes et les outils ... 20
9.3.4 Analyser et interpréter les résultats ... 26
9.3.5 Valoriser le projet ... 35
9.3.6 Rédiger les parties « évaluation » et « bilan » d'un dossier ... 42
9.3.7 Analyser des données avant/après appariées ... 47
9.3.8 L'évaluation qualitative ... 50
9.3.9 Évaluer l'animation : observer et s'auto-évaluer ... 55
9.3.10 Évaluer l'équité et les effets environnementaux ... 59
9.3.11 Présenter un projet et ses résultats à l'oral ... 62
9.3.12 Le rapport d'évaluation : un modèle de plan commenté ... 66
9.3.13 Évaluer à distance : mesurer le maintien des changements ... 69
9.3.14 Fil rouge : l'évaluation et la valorisation du projet des Tilleuls ... 71
9.4 Approfondissements ... 72
9.4.1 L'évaluation participative ... 72
9.4.2 Les données probantes en prévention ... 73
9.4.3 Les effets indésirables d'une action de prévention ... 75
9.4.4 Le coût de l'évaluation et sa proportionnalité ... 76
9.4.5 Évaluation et apprentissage organisationnel ... 77
9.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 ... 78
9.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles ... 79
Ce que le jury attend sur l'évaluation et la valorisation ... 82
9.7 L'essentiel à retenir ... 83
9.8 Entraînement ... 84
9.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) ... 84
9.8.2 Exercices ... 85
9.8.3 Questions de réflexion ... 88
9.8.4 Étude de cas ... 89
9.8.5 Mises en situation express ... 90
9.8.6 Exercices complémentaires ... 92
9.9 Glossaire ... 94
9.10 Renvois bibliographiques par notion ... 95
9.12 Bibliographie numérotée ... 96

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- définir l'évaluation d'un projet de santé publique et en distinguer les types (processus, résultats, impact ; formative, sommative ; interne, externe) ;
- utiliser les critères d'évaluation (pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact, durabilité) et le modèle RE-AIM ;
- construire des indicateurs (ressources, activité, résultat, impact) avec valeur initiale, valeur cible, source et fréquence ;
- choisir une méthode et des outils d'évaluation adaptés au public, et prévoir l'évaluation dès la conception ;
- calculer et interpréter les indicateurs : taux de réalisation, taux de participation, taux d'atteinte, progression, gain normalisé, coût par résultat ;
- discuter les limites d'une évaluation (biais, effectif, absence de groupe de comparaison, recul) ;
- valoriser un projet : restitution aux participants, bilan aux financeurs, communication, capitalisation, pérennisation et transférabilité ;
- rédiger les parties « évaluation » et « bilan, perspectives » d'un dossier de projet.

9.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.1	Cœur de la compétence : construire et conduire l'évaluation, s'auto-évaluer, ajuster, valoriser	Démarche d'évaluation construite ; auto-évaluation argumentée ; ajustements envisagés ; valorisation
C3.2	Évaluer les ateliers (grilles d'observation, dégustation, satisfaction)	Démarche d'évaluation adaptée
C3.3	Traiter et analyser les données d'évaluation, rédiger un rapport	Traitement et analyse réalisés ; normes de rédaction du rapport respectées
C3.5	Restituer et communiquer les résultats selon les destinataires (participants, financeurs, professionnels)	Supports et contenus adaptés au public ; expression écrite et orale maîtrisée

9.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Évaluation : définitions, types	Distinguer processus, résultats, impact	Pas d'évaluation d'impact sanitaire attendue d'un projet de stage
Critères et modèles	Utiliser les critères d'évaluation	Critères du comité d'aide au développement de l'OCDE ; RE-AIM
Indicateurs	Construire des indicateurs complets	Valeur initiale, cible, source, fréquence ; fiche F12
Outils d'évaluation	Construire un questionnaire, une grille d'observation	Accessibilité (chapitre 5) ; RGPD (chapitre 6)
Analyse des résultats	Calculer, représenter, interpréter, discuter	Outils statistiques simples ; limites

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Valorisation	Communiquer les résultats selon les destinataires	Restitution, bilan, poster, capitalisation
Pérennisation, transférabilité	Proposer des perspectives argumentées	Conditions de réussite

9.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : activité 3.1 « Suivi et évaluation du projet » et « Valorisation du projet » ; compétence C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 63 pour les étapes « Évaluation » et « Valorisation » et les tableaux de bord, p. 108 et 109 pour l'apport des autres blocs). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 9.2.2.

Texte	Critère ou notion	Où dans ce cours
Référentiel, C3.1	« Démarche d'évaluation du projet construite »	9.3.1 à 9.3.3 ; 9.3.6 ; 9.3.12
Référentiel, C3.1	« Autoévaluation du projet argumentée » ; « Ajustements envisagés »	9.3.4 ; 9.3.9 (s'auto-évaluer) ; 9.3.13
Référentiel, C3.1	« Valorisation du projet »	9.3.5 ; 9.3.11 (présenter à l'oral) ; 9.3.14 (fil rouge)
Guide 2025, p. 63	Étapes « Évaluation » et « Valorisation » ; tableaux de bord ; tableur	9.3.1 à 9.3.5 ; 9.3.7 (données appariées) ; chapitre 8 (tableau de bord)
Guide 2025, p. 63	Questionnaire, de la rédaction au dépouillement	9.3.3 ; 9.3.4 ; 9.3.8 (évaluation qualitative)
Guide 2025, p. 108 et 109	Étapes du projet partagées avec les autres blocs (évaluation et valorisation)	9.3.5 ; 9.3.14
Référentiel, C3.1	« Règles éthiques, juridiques et déontologiques respectées »	9.3.3 (RGPD des questionnaires) ; 9.3.10 (équité) ; chapitre 6

9.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le fascicule du CNED *Environnement professionnel – Les essentiels* (2e année) traite l'évaluation en trois endroits : la définition des indicateurs (séquence 1), l'épidémiologie évaluative et les étapes du projet (séquence 2). Le tableau relie chaque passage à ce cours.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Essentiels S1 §5 (p. 6)	Définition d'un indicateur : taux ou pourcentage, comparable, calculé à date régulière	9.3.1 (encadré « Repères » du CNED) ; 9.3.2 (construire les indicateurs)
Essentiels S2 §1 (p. 9)	Épidémiologie évaluative : « Quel est l'impact d'une action de santé publique ? »	9.3.1 (encadré « Repères » du CNED ; évaluation d'impact) ; chapitre 16
Essentiels S2 §2 (p. 11 et 12)	Étapes du projet jusqu'à l'évaluation (doc. 3) ; communication, valorisation et capitalisation	9.3.1 ; 9.3.5 (valoriser, capitaliser) ; 9.3.11

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été précisé

- **Moment de l'évaluation** : le doc. 3 du CNED place l'évaluation en fin de démarche. Les guides actuels (et ce cours) demandent de la **prévoir dès la conception** : indicateurs, valeur initiale et outils sont définis

avant l'action, sinon on ne peut pas mesurer d'évolution.

- **Critères d'évaluation** : les critères du comité d'aide au développement de l'OCDE ont été révisés en décembre 2019 (ajout de la **cohérence**) ; ils sont donc six : pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact, viabilité (ou durabilité).
- **Restauration collective** : les objectifs de la loi EGalim (au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de bio) s'appliquent depuis le 1er janvier 2022 à la restauration collective publique et depuis le 1er janvier 2024 à la restauration collective privée (loi Climat et résilience du 22 août 2021).
- **Compte rendu financier** : il se fait avec le Cerfa n° 15059*02, dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée (loi du 12 avril 2000, article 10).
- **Politique de référence** : le PNNS 5 (2026-2030), lancé le 8 avril 2026, remplace le PNNS 4.

9.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Interventions probantes** : le répertoire de Santé publique France et le portail CAPS (capitalisation des expériences en promotion de la santé) sont enrichis régulièrement : vérifiez si une évaluation d'une action proche de la vôtre a été publiée.
- **Outil de catégorisation des résultats** (Promotion Santé Suisse, adaptation diffusée par Santé publique France) : vérifiez la version en vigueur.
- **Compte rendu financier** : le formulaire Cerfa n° 15059*02 « Compte rendu financier de subvention » est exigé par les financeurs publics (version en vigueur en octobre 2026).
- **PNNS 5 (2026-2030)** : lancé le 8 avril 2026 (3 axes, 20 mesures), il fixe notamment l'objectif de réduire de 30 % le surpoids et l'obésité des enfants et des adolescents ; ses indicateurs de suivi peuvent servir de référence pour vos propres indicateurs de résultats.

9.3.1 Qu'est-ce qu'évaluer ?

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S1 §5 (p. 6) ; Essentiels M1 S2 §1 (p. 9) ; Essentiels M1 S2 §2 (p. 11 et 12)

Définition – Évaluation

Démarche qui consiste à **porter un jugement de valeur** sur une action, un projet ou un programme, à partir d'**informations recueillies de façon rigoureuse** et de **critères explicites**, dans le but de **prendre des décisions** (poursuivre, ajuster, arrêter, étendre) et de **rendre compte**. Évaluer, ce n'est pas seulement mesurer : c'est comparer ce qui est observé à ce qui était attendu, et en tirer des conclusions utiles.

Attention – Évaluation, contrôle, suivi

Le **suivi** (ou monitoring) recueille en continu des données sur le déroulement (chapitre 8 : tableau de bord) ; le **contrôle** vérifie la conformité à une règle (un financeur contrôle l'usage de la subvention) ; l'**évaluation** juge la **valeur** de l'action au regard de ses objectifs et de critères, et produit des recommandations. Le suivi alimente l'évaluation.

Pourquoi évaluer ?

- **Améliorer** l'action en cours (ajuster les séances) et les actions futures.

- **Rendre compte** aux financeurs, aux partenaires, aux participants et au jury.
- **Démontrer l'utilité** de l'action pour obtenir sa **pérennisation**.
- **Produire des connaissances** utiles à d'autres (capitalisation, données probantes).
- **Mobiliser** l'équipe et les participants autour des résultats.

Les types d'évaluation

Classement	Types
Selon le moment	Ex ante (avant : évaluer la pertinence et la faisabilité) ; en cours ou intermédiaire (pour ajuster) ; ex post ou finale (à la fin) ; à distance (quelques mois après, pour mesurer le maintien)
Selon la finalité	Formative (améliorer pendant l'action) ; sommative (juger les résultats à la fin)
Selon l'objet	Processus (mise en œuvre) ; résultats (atteinte des objectifs spécifiques) ; impact (effets à long terme, santé, inégalités)
Selon l'évaluateur	Interne ou auto-évaluation (par l'équipe) ; externe (par un tiers indépendant) ; participative (avec les personnes concernées)

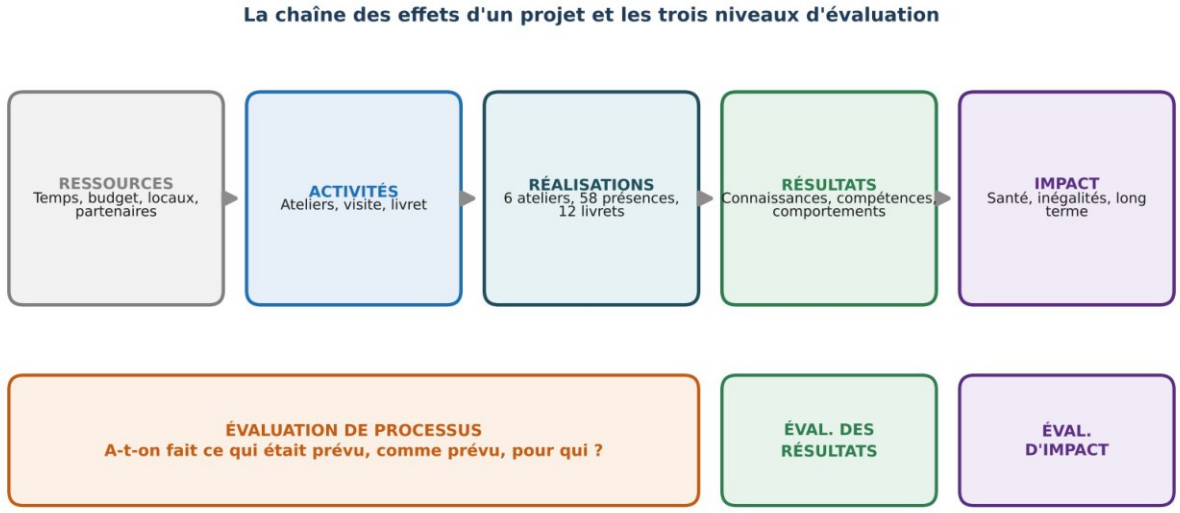


Figure 9.1 – La chaîne des effets et les trois niveaux d'évaluation

Comprendre le schéma – Figure 9.1

1. Un projet transforme des **ressources** (temps, budget, locaux, partenaires) en **activités** (ateliers), qui produisent des **réalisations** mesurables (6 ateliers, 58 présences, 12 livrets distribués).
2. Ces réalisations doivent entraîner des **résultats** chez le public : connaissances, compétences, comportements (les familles cuisinent davantage les légumes secs).
3. À long terme, on espère un **impact** : amélioration de l'état de santé (moins de surpoids chez les enfants), réduction des inégalités.
4. L'**évaluation de processus** porte sur les trois premiers maillons : a-t-on fait ce qui était prévu, comme prévu, pour le public prévu, avec les moyens prévus ?
5. L'**évaluation des résultats** vérifie l'atteinte des **objectifs spécifiques** ; l'**évaluation d'impact** vise l'**objectif général**.
6. Un projet de stage évalue toujours le processus et les résultats ; l'impact sanitaire est rarement mesurable (durée trop courte, effectif trop faible, multiples facteurs) : on l'**argumente** à partir de la littérature, sans prétendre l'avoir démontré.

Les critères d'évaluation

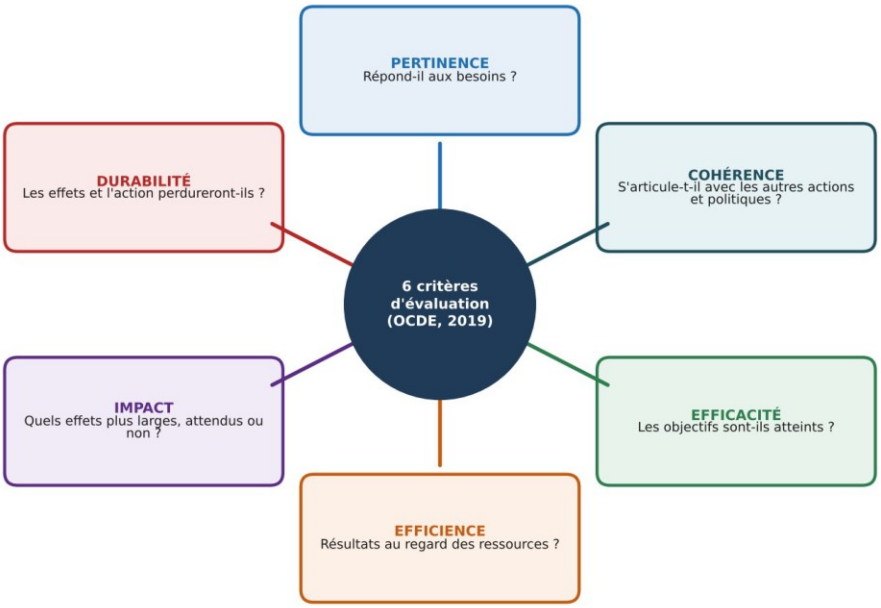


Figure 9.2 – Les six critères d'évaluation

Comprendre le schéma – Figure 9.2

1. Pertinence : le projet répond-il aux besoins identifiés et aux priorités (diagnostic, politiques) ?

2. Cohérence : s'articule-t-il avec les autres actions du territoire et les politiques (cohérence externe) ? Ses objectifs, actions et moyens sont-ils cohérents entre eux (cohérence interne) ?

3. Efficacité : les objectifs (spécifiques et opérationnels) sont-ils atteints ?

4. Efficience : les résultats sont-ils obtenus avec un usage raisonnable des ressources (coût par participant, par résultat) ?

5. Impact : quels effets plus larges, positifs ou négatifs, attendus ou non (des familles ont créé un groupe d'achats groupés ; une famille s'est sentie mise à l'écart) ?

6. Durabilité : les effets et l'action se maintiendront-ils après la fin du financement ?

7. Ces six critères ont été redéfinis en 2019 par le comité d'aide au développement de l'OCDE ; ils sont largement utilisés dans l'évaluation des politiques publiques et par les financeurs.

Les questions évaluatives : savoir ce que l'on veut juger

Avant de choisir des indicateurs, il faut savoir **ce que l'on cherche à savoir**. Les **questions évaluatives** sont les quelques questions auxquelles l'évaluation devra répondre à la fin du projet. Elles orientent tout le reste : les indicateurs, les outils, le calendrier et le plan du rapport. Une évaluation sans questions évaluatives produit souvent beaucoup de chiffres et peu de conclusions.

Une bonne question évaluative porte sur un **critère** (pertinence, efficacité, efficience…), elle est **utile pour une décision** et l'on peut **y répondre** avec les moyens disponibles. On en retient en général trois à six pour un projet de stage.

Critère	Exemple de question évaluative	Décision qu'elle éclaire
Pertinence	Les ateliers correspondent-ils aux difficultés exprimées par les familles lors du diagnostic ?	Garder ou modifier le contenu des ateliers
Cohérence	Le projet complète-t-il, sans le dupliquer, le programme de la PMI du quartier ?	Organiser les actions avec les partenaires

Critère	Exemple de question évaluative	Décision qu'elle éclaire
Efficacité	La part des familles qui proposent un fruit au goûter a-t-elle atteint la cible fixée ?	Reconduire ou ajuster
Efficience	Le coût par famille est-il raisonnable au regard des résultats et d'actions comparables ?	Choisir entre plusieurs formules
Impact et effets inattendus	Le projet a-t-il eu des effets non prévus, positifs ou négatifs, sur les familles ou la structure ?	Corriger un effet indésirable, valoriser un effet positif
Durabilité	L'action pourra-t-elle continuer sans la stagiaire et sans la subvention ?	Préparer la pérennisation

Méthode pas à pas – Rédiger les questions évaluatives

1. Partir des objectifs : chaque objectif spécifique appelle au moins une question d'efficacité.

2. Interroger les commanditaires : que veulent savoir la structure, le financeur, les participants ? Leurs attentes ne sont pas toujours les mêmes.

3. Couvrir plusieurs critères : efficacité et processus au minimum ; pertinence et durabilité si une décision de reconduction est prévue.

4. Vérifier la faisabilité : pour chaque question, peut-on recueillir l'information (outil, temps, accès au public) ?

5. Hiérarchiser : garder les questions les plus utiles ; une question à laquelle on ne pourra pas répondre est supprimée ou reformulée.

Attention – Question évaluative ou question de questionnaire ?

La question évaluative est posée **à l'évaluation**, pas aux participants. « Les participants ont-ils amélioré leur lecture des étiquettes ? » est une question évaluative ; pour y répondre, on posera aux participants des questions concrètes (« Parmi ces deux céréales, laquelle contient le moins de sucres ? ») et on observera leur lecture d'une étiquette.

Exemple – Les questions évaluatives d'un projet en foyer d'hébergement

Un foyer d'hébergement pour adultes handicapés (structure fictive) met en place des ateliers « Je compose mon plateau » au self. La directrice et le financeur veulent savoir s'il faut étendre l'action aux deux autres foyers de l'association. Questions retenues : 1) Les résidents composent-ils des plateaux plus équilibrés en fin de projet (efficacité) ? 2) Les supports imagés sont-ils compris par tous les résidents, y compris ceux qui ne lisent pas (pertinence et accessibilité) ? 3) L'équipe du self peut-elle poursuivre l'action seule (durabilité) ? 4) Quelles conditions faudrait-il réunir dans les deux autres foyers (transférabilité) ? Chaque question renvoie à la décision attendue : étendre ou non.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.1

Une association propose des « paniers fraîcheur » à prix réduit et deux ateliers de cuisine par mois aux étudiants d'un campus (projet fictif). Le financeur doit décider s'il renouvelle sa subvention. Rédigez quatre questions évaluatives, en précisant pour chacune le critère auquel elle se rattache.

Corrigé

Exemples. Efficacité : « La part des étudiants inscrits qui consomment des légumes au moins une fois par jour a-t-elle augmenté et atteint la cible ? » Pertinence : « Les étudiants inscrits sont-ils ceux qui ont le plus de difficultés financières, comme le prévoyait le diagnostic ? » Efficience : « Le coût par étudiant touché est-il

compatible avec le budget du financeur ? » Durabilité : « Les associations étudiantes peuvent-elles assurer la distribution des paniers sans salarié ? » Toute question est acceptée si elle est utile à la décision de renouvellement et si l'on peut y répondre.

Qui évalue ? Avantages et limites de chaque position

L'évaluation peut être conduite par l'équipe du projet, par une personne extérieure ou avec les participants. Chaque position a des avantages et des limites ; dans un projet de stage, on combine souvent une **auto-évaluation** rigoureuse et un **regard extérieur** (tutrice, partenaire, comité de pilotage).

Évaluateur	Avantages	Limites	Pour limiter les biais
Interne (l'équipe, la stagiaire)	Connaissance fine du projet ; coût faible ; apprentissage direct pour l'équipe	Risque de complaisance ; difficulté à voir ses propres erreurs ; participants peu à l'aise pour critiquer	Questionnaires anonymes recueillis par une autre personne ; relecture par la tutrice ; critères fixés à l'avance
Externe (consultant, université, financeur)	Indépendance ; regard neuf ; crédibilité auprès des financeurs	Coût ; connaissance limitée du terrain ; évaluation parfois vécue comme un contrôle	Associer l'équipe au cahier des charges ; restituer les résultats à l'équipe
Participative (avec les participants)	Critères qui ont du sens pour le public ; pouvoir d'agir ; interprétation plus juste	Temps ; animation exigeante ; difficulté à mobiliser	Méthodes simples (photo-expression, mur des avis) ; restitution et discussion des résultats
Mixte	Combine la connaissance du terrain et la prise de recul	Coordination	Répartir clairement les rôles dans le plan d'évaluation

Définition – Auto-évaluation

Évaluation conduite par les personnes qui ont mené l'action, sur leur propre travail, à l'aide de critères définis à l'avance. Elle n'est pas un jugement de soi « au ressenti » : elle s'appuie sur des données (grilles d'observation, présences, retours des participants) et sur l'avis de personnes extérieures.

L'éthique de l'évaluation

Évaluer, c'est recueillir des informations sur des personnes. L'évaluation doit donc respecter les mêmes principes que le reste du projet (chapitre 6).

- **Informer** les participants : pourquoi on les interroge, ce que deviendront leurs réponses.
- **Recueillir leur accord** et laisser la liberté de ne pas répondre, sans conséquence sur leur participation.
- **Limiter les données** au strict nécessaire (principe de minimisation du RGPD) ; éviter les données de santé si elles ne sont pas indispensables.
- **Garantir la confidentialité** : codes anonymes, stockage protégé, résultats présentés de façon collective.
- **Ne pas nuire** : des questions sur le poids ou sur les difficultés financières peuvent blesser ; on les formule avec tact ou on y renonce.
- **Restituer** les résultats aux personnes qui ont donné de leur temps.

Attention – L'évaluation n'est pas un contrôle des participants

Un participant ne doit jamais se sentir « noté ». On évalue l'**action**, pas les personnes. Dans une grille d'observation, on écrit par exemple « 7 participants sur 10 réussissent la lecture de l'étiquette » et non une liste nominative de réussites et d'échecs. Le vocabulaire compte : on parle de « bilan » ou de « faire le point ensemble » plutôt que de « test ».

À vous de jouer – Exercice d'application 9.2

Une stagiaire a animé seule un cycle d'ateliers dans une épicerie sociale (structure fictive). Elle prévoit de faire remplir le questionnaire de satisfaction en face à face, à la fin du dernier atelier, en posant elle-même les questions. Expliquez les deux biais principaux de cette organisation et proposez trois améliorations.

Corrigé

Biais : la **désirabilité sociale** (les participants n'osent pas critiquer devant l'animatrice qu'ils apprécient) et le **biais de l'évaluateur** (la stagiaire peut, sans le vouloir, orienter les réponses ou les interpréter favorablement). Améliorations : un questionnaire anonyme rempli seul, avec des pictogrammes pour les personnes qui lisent difficilement ; une urne ou un recueil par une bénévole de l'épicerie ; une question ouverte sur ce qui pourrait être amélioré ; une relecture des résultats par la tutrice.

La logique d'intervention : expliciter les hypothèses du projet

Tout projet repose sur une suite d'**hypothèses** : « si les familles apprennent à cuisiner les légumes secs, **alors** elles en cuisineront plus souvent, **alors** leurs enfants en mangeront davantage ». Cette suite s'appelle la **logique d'intervention** (ou théorie d'action). L'expliciter aide à évaluer : quand un résultat n'est pas atteint, on peut chercher à quel maillon la chaîne s'est rompue.

Maillon	Hypothèse	Ce que l'on vérifie
Activités → réalisations	Les ateliers prévus ont lieu, avec le public prévu	Taux de réalisation, profil des participants
Réalisations → connaissances et compétences	Les participants comprennent et savent faire	Quiz, grille d'observation
Compétences → comportements	Ils refont les recettes à la maison	Questionnaire avant / après, verbatims
Comportements → effets sur la santé	Une consommation régulière améliore l'équilibre alimentaire	Argumentée par la littérature, rarement mesurée

Exemple – Retrouver le maillon faible

Dans un cycle d'ateliers pour des parents (projet fictif), le quiz montre une forte progression des connaissances (score moyen de 4,8 à 8,1 sur 10), mais la part des familles qui servent des légumes au dîner ne change presque pas (5 familles sur 14 avant, 6 sur 14 après). La chaîne s'est rompue entre **compétences** et **comportements**. Les entretiens montrent pourquoi : les légumes frais sont jugés trop chers en fin de mois, et les enfants refusent les nouvelles recettes. L'évaluation conduit à ajouter une action sur l'**accès** (bons d'achat au marché) et des recettes testées avec les enfants. Sans logique d'intervention, on aurait pu conclure à tort que « les ateliers ne servent à rien ».

Astuce – Une phrase « si… alors… » par objectif

Dans votre dossier, écrivez pour chaque objectif spécifique la phrase « Si [action], alors [changement], parce que [mécanisme] ». Exemple : « Si les élèves goûtent chaque semaine un légume préparé de trois façons, alors ils l'accepteront plus souvent à la cantine, parce que l'exposition répétée diminue la néophobie alimentaire. » Cette phrase montre au jury que vos actions ne sont pas choisies au hasard, et elle indique quoi mesurer.

Résultats attendus, effets inattendus

La logique d'intervention décrit les effets **attendus**. Mais une action produit aussi des effets **inattendus**, que l'on ne cherche pas si l'on se limite aux indicateurs prévus. Ils peuvent être positifs (des parents créent un groupe d'entraide) ou négatifs (des enfants se moquent d'un camarade qui apporte un goûter « interdit »). C'est pourquoi tout plan d'évaluation comporte au moins une **question ouverte** et un temps d'**observation libre** (carnet de bord).

À vous de jouer – Exercice d'application 9.3

Un collège (établissement fictif) installe une fontaine à eau dans la cour et organise deux séances en classe sur les boissons sucrées. Écrivez la logique d'intervention en trois maillons « si… alors… », puis proposez un indicateur pour chacun.

Corrigé

Exemple. 1) Si une fontaine est installée et entretenue, alors les élèves ont accès à de l'eau fraîche gratuite pendant la récréation : indicateur, nombre de remplissages par jour (compteur) ou observation des passages. 2) Si les élèves comprennent la teneur en sucres des boissons (séances en classe) et disposent d'eau, alors ils boivent plus d'eau et moins de boissons sucrées au collège : indicateur, part d'élèves déclarant apporter une boisson sucrée, ventes du distributeur s'il existe. 3) Si cette habitude se maintient, alors leurs apports en sucres diminuent : argumenté par la littérature, non mesuré dans le projet.

Repères – Évaluation, indicateur et épidémiologie évaluative (CNED)

- **Épidémiologie évaluative** (CNED, Essentiels, séquence 2) : c'est la branche de l'épidémiologie qui répond à la question « quel est l'impact d'une action de santé publique ? ». Elle complète l'épidémiologie **descriptive** (quel est le risque dans une population ?) et **analytique** (quels facteurs augmentent ce risque ?), vues au chapitre 16.
- **Indicateur** (CNED, séquence 1) : instrument de mesure, souvent exprimé en taux ou en pourcentage, qui rend les informations quantifiables et comparables ; c'est une donnée chiffrée, calculée à date régulière. Dans un projet, on lui ajoute une valeur initiale, une cible, une source et une date de mesure (9.3.2).
- **Évaluation, dernière étape… et première** : le CNED place l'évaluation à la fin de la démarche de projet (doc. 3) ; ce cours insiste sur le fait qu'elle se **prépare dès la conception** (indicateurs et état initial) et qu'elle nourrit un nouveau diagnostic.
- **Capitalisation** : garder les outils et les leçons du projet pour de futurs projets (9.3.5).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 9.3.1 – Qu'est-ce qu'évaluer ?

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez la différence entre suivi, contrôle et évaluation.
2. Citez les six critères d'évaluation de l'OCDE.
3. Quelle est la différence entre évaluation des résultats et évaluation d'impact ?
4. Qu'est-ce qu'une question évaluative ? Donnez un exemple.
5. Citez un avantage et une limite de l'auto-évaluation.
6. Pourquoi faut-il toujours prévoir une question ouverte dans une évaluation ?

Corrigé – Point d'étape 9.3.1

1. Le suivi recueille en continu des données sur le déroulement ; le contrôle vérifie la conformité à une règle ; l'évaluation juge la valeur de l'action au regard de ses objectifs et de critères, pour décider.
2. Pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact, durabilité.

3. L'évaluation des résultats vérifie l'atteinte des objectifs spécifiques (changements chez le public) ; l'évaluation d'impact vise l'objectif général (effets à long terme sur la santé ou les inégalités), rarement mesurable dans un projet de stage.
4. Une question à laquelle l'évaluation devra répondre, liée à un critère et utile à une décision ; par exemple : « La part des familles qui proposent un fruit au goûter a-t-elle atteint la cible ? »
5. Avantage : bonne connaissance du projet, coût faible. Limite : risque de complaisance et de désirabilité sociale.
6. Pour repérer les effets inattendus, positifs ou négatifs, que les indicateurs prévus ne mesurent pas.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 9.3.2.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux des types d'évaluation et des questions évaluatives.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 9.3.1 et je refais les exercices d'application.

9.3.2 Construire les indicateurs

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S1 §5 (p. 6)

Définition – Indicateur

Variable **observable** et **mesurable** qui renseigne sur l'atteinte d'un objectif ou le déroulement d'une action. Un indicateur complet précise : son **intitulé**, son **mode de calcul** (numérateur, dénominateur), sa **valeur initiale** (état de départ), sa **valeur cible**, sa **source** (outil de recueil), la **fréquence** et le **moment** du recueil, le **responsable**.

Type d'indicateur	Ce qu'il mesure	Exemples (projet des Tilleuls)
Ressources (moyens)	Moyens mobilisés	Budget dépensé ; heures de diététicienne ; nombre de partenaires engagés
Activité (réalisation)	Ce qui a été fait	Nombre d'ateliers réalisés / prévus ; nombre de livrets distribués ; visite réalisée
Participation	Qui a été touché	Familles inscrites ; taux de présence ; part des familles du public prioritaire ; profil des participants
Satisfaction	Perception des participants	Part de participants satisfaits ; note moyenne ; verbatims
Résultat	Changements chez le public	Score de connaissances ; part des familles consommant des légumes secs ≥ 2 fois par semaine ; recettes refaites
Impact	Effets à long terme	Prévalence du surpoids chez les enfants du quartier (hors portée d'un projet de 3 mois)

Exemple – Un indicateur complet

Intitulé : part des familles participantes consommant des légumes secs au moins 2 fois par semaine. **Calcul** : nombre de familles déclarant ≥ 2 fois / nombre de familles ayant répondu × 100. **Valeur initiale** : 25 % (3/12, questionnaire du 7 mars 2028). **Cible** : ≥ 60 % (au moins 8 familles). **Source** : question 4 du questionnaire avant/après. **Moment** : 1er et 6e ateliers, puis appel téléphonique à 3 mois. **Responsable** : Inès (saisie), diététicienne (validation).

Les qualités d'un bon indicateur

Un indicateur n'est utile que s'il mesure vraiment ce que l'on veut savoir et s'il peut être recueilli sans difficulté. On vérifie cinq qualités avant de l'inscrire dans le plan d'évaluation.

Qualité	Question à se poser	Exemple de défaut
Pertinent (valide)	Mesure-t-il bien l'objectif visé ?	« Nombre de livrets distribués » pour mesurer un changement de comportement
Fiable	Donnera-t-il le même résultat s'il est mesuré par une autre personne, avec le même outil ?	« Les participants semblent mieux manger » (appréciation personnelle)
Sensible	Peut-il varier pendant la durée du projet ?	« Prévalence de l'obésité dans la commune » pour un cycle de trois mois
Faisable	Peut-on le recueillir avec le temps, les outils et l'accès au public disponibles ?	Un relevé alimentaire de sept jours pour 60 participants, sans moyen de saisie
Compréhensible	Les partenaires comprendront-ils ce qu'il signifie ?	Un score composite non expliqué

Définition – Numérateur et dénominateur

La plupart des indicateurs sont des **proportions** : le **numérateur** compte les personnes qui présentent la caractéristique (familles qui cuisinent des légumes secs au moins deux fois par semaine) ; le **dénominateur** compte les personnes concernées (familles qui ont répondu au questionnaire). Préciser le dénominateur évite les confusions : « 9 familles » n'a pas le même sens sur 12 répondantes que sur 30 inscrites.

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs

Un indicateur peut être **quantitatif** (un nombre, un pourcentage, une moyenne) ou **qualitatif** (une description structurée). Un indicateur qualitatif reste rigoureux s'il est défini à l'avance : par exemple « les participants citent au moins deux changements concrets dans leurs achats, lors de l'entretien collectif de bilan ». Les deux types se complètent : le quantitatif mesure l'ampleur, le qualitatif explique.

Exemple – Améliorer un indicateur pas à pas

Version 1 : « Les jeunes mangent mieux. » Ce n'est pas un indicateur : rien n'est mesurable. Version 2 : « Nombre de jeunes qui prennent un petit-déjeuner. » Mesurable, mais sans dénominateur ni fréquence. Version 3 : « Part des jeunes du groupe qui déclarent prendre un petit-déjeuner au moins 5 jours sur 7, parmi ceux qui ont répondu au questionnaire. » Pertinent, mesurable et comparable avant et après. On complète enfin par la valeur initiale, la cible, la source, le moment et le responsable (9.3.2).

Attention – Trop d'indicateurs tue l'évaluation

Un projet de stage n'a pas besoin de vingt indicateurs. On en retient en général **un ou deux par objectif spécifique**, quelques indicateurs de processus (réalisation, participation, budget) et un indicateur de satisfaction. Chaque indicateur supplémentaire demande du temps de recueil, de saisie et d'analyse.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.4

Pour un objectif « augmenter la consommation d'eau des salariés d'un entrepôt pendant leur poste » (projet fictif), on propose trois indicateurs : a) « nombre de gourdes distribuées » ; b) « les salariés boivent plus » ; c) « litres d'eau consommés aux fontaines par salarié présent et par jour ». Indiquez pour chacun ses qualités et ses défauts.

Corrigé

a) Indicateur de **réalisation**, facile à recueillir, mais il ne mesure pas la consommation : il n'est pas pertinent pour l'objectif. b) Ce n'est pas un indicateur : ni mesurable, ni fiable. c) Pertinent, fiable (compteur des fontaines), sensible et faisable ; on le rapporte au nombre de salariés présents pour neutraliser les variations d'effectif. Sa limite : il ne compte pas l'eau apportée de la maison ; on peut le compléter par une question sur la consommation déclarée.

Fixer une valeur cible réaliste

La **valeur cible** est le niveau que l'on espère atteindre. Trop basse, elle ne motive personne et n'a pas de sens ; trop haute, elle conduit à un « échec » qui décourage l'équipe et les financeurs. Une cible se justifie : on doit pouvoir expliquer d'où elle vient.

Source pour fixer la cible	Exemple
L'état initial	30 % au départ : viser 50 % (+ 20 points) sur un cycle de deux mois
Les résultats d'actions comparables	Une évaluation publiée d'un programme proche montre une progression d'environ 15 à 25 points
Une référence nationale ou un repère	Repère du PNNS, recommandation de l'ANSES, objectif d'un plan régional
Les moyens du projet	Six séances de 1 h 30 ne permettent pas de transformer toutes les habitudes
L'avis des partenaires et du public	Le comité de pilotage valide la cible ; les participants peuvent fixer leurs propres objectifs

Exemple – Calcul détaillé : traduire une cible en effectifs

Dans un groupe de 30 adhérents d'un club sportif (club fictif), 9 déclarent prendre une collation adaptée après l'entraînement : valeur initiale 9 / 30 = **30 %**. La cible est fixée à **50 %**, soit 0,50 × 30 = **15 adhérents**, donc 6 de plus qu'au départ. Si l'on prévoit qu'environ 80 % des adhérents répondront au questionnaire final, soit 0,80 × 30 = **24 répondants**, la cible correspond à 0,50 × 24 = **12 répondants** sur 24. Traduire la cible en nombre de personnes aide à juger si elle est réaliste.

Exemple – Calcul détaillé : une cible exprimée en réduction relative

Un objectif est formulé ainsi : « réduire d'un quart la part des élèves qui ne prennent rien le matin ». Valeur initiale : 40 %. Une réduction relative d'un quart donne 40 × (1 − 0,25) = 40 × 0,75 = **30 %**, soit une baisse de **10 points**. Attention à ne pas confondre avec une baisse de 25 points (40 − 25 = 15 %), beaucoup plus ambitieuse. On écrit toujours la cible finale en clair : « passer de 40 % à 30 % ».

Astuce – Mesurer la valeur initiale avant de fixer la cible

Quand l'état initial n'est pas connu, on fixe une cible **provisoire** à partir d'actions comparables, puis on l'ajuste après la mesure initiale, en le notant dans le dossier (« cible révisée le 12 mars après la mesure initiale, avec l'accord du comité de pilotage »). Changer la cible **après** avoir vu les résultats finaux, en revanche, n'est pas honnête.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.5

Dans un EHPAD (structure fictive), 18 résidents sur 45 prennent la collation de l'après-midi. Le projet vise 60 % à la fin de l'année. a) Calculez la valeur initiale en pourcentage. b) Traduisez la cible en nombre de

résidents. c) Quelle progression en points cela représente-t-il ? d) Jugez le réalisme de cette cible.

Corrigé

a) 18 / 45 × 100 = **40 %**. b) 0,60 × 45 = **27 résidents**, soit 9 de plus. c) 60 − 40 = **+ 20 points**. d) La cible est ambitieuse mais réaliste sur une année si l'action agit à la fois sur l'offre (collations variées, adaptées aux textures), sur l'horaire et sur l'accompagnement par le personnel ; elle doit être discutée avec l'équipe soignante, en tenant compte des résidents dont l'état de santé limite l'appétit.

Le plan d'évaluation complet : un exemple commenté

Le plan d'évaluation rassemble dans un seul tableau tout ce qui sera mesuré. Il se construit en même temps que les objectifs et figure dans le dossier de projet. L'exemple ci-dessous porte sur un projet fictif : « Le goûter, on s'en occupe », mené dans un accueil de loisirs auprès de 36 enfants de 6 à 10 ans et de leurs parents.

Niveau	Indicateur	Valeur initiale	Cible	Outil et source	Moment	Responsable
Ressources	Budget dépensé / prévu	–	90 à 105 %	Tableau de suivi budgétaire	Chaque mois	Directrice
Réalisation	Ateliers réalisés / prévus	–	8 sur 8	Carnet de bord	Après chaque atelier	Stagiaire
Participation	Taux de présence des enfants	–	≥ 80 %	Feuille d'émargement	Chaque atelier	Animateur
Participation	Parents présents à au moins un atelier	–	≥ 15 familles sur 30	Feuille d'émargement	Fin du cycle	Stagiaire
Satisfaction	Enfants qui ont aimé les ateliers	–	≥ 80 %	Échelle de smileys	Dernier atelier	Animateur
Résultat 1	Goûters apportés qui contiennent un fruit ou un produit laitier	35 %	≥ 55 %	Observation des goûters pendant 5 jours	Avant le cycle, puis 2 semaines après	Stagiaire et animateurs
Résultat 2	Enfants qui citent trois composantes d'un goûter équilibré	20 %	≥ 60 %	Jeu d'association d'images	Premier et dernier atelier	Stagiaire
Effets inattendus	Changements cités par les parents et les animateurs	–	–	Question ouverte, carnet de bord	Fin du cycle	Stagiaire

Le calendrier des recueils

Le plan d'évaluation se traduit en **calendrier** : chaque recueil est placé dans le planning du projet (Gantt, chapitre 8). On vérifie qu'aucun recueil n'est oublié et que les moments choisis sont comparables.

Période	Recueil
Semaine 1 (avant le cycle)	Observation des goûters pendant 5 jours ; jeu d'images au premier atelier
Semaines 2 à 9	Émargement, carnet de bord, suivi budgétaire
Semaine 9	Jeu d'images au dernier atelier ; smileys ; question ouverte aux parents
Semaine 11	Observation des goûters pendant 5 jours (même saison, mêmes jours)
Semaine 12	Saisie, analyse, rédaction du bilan

Attention – Comparer ce qui est comparable

Les deux observations des goûters doivent avoir lieu dans les **mêmes conditions** : mêmes jours de la semaine, même durée, même grille, même personne si possible, et hors période particulière (sortie, anniversaire, veille de vacances). Sinon, la différence observée peut venir des conditions de mesure et non de l'action.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.6

Dans le plan ci-dessus, la directrice propose de supprimer l'observation des goûters de la semaine 11 pour gagner du temps et de ne garder que le jeu d'images. Expliquez ce que l'évaluation perdrait et proposez une solution plus légère.

Corrigé

Sans l'observation finale, on ne mesure plus le **comportement** (le contenu réel des goûters), seulement les **connaissances** des enfants ; or le projet vise un changement de comportement, et des connaissances ne se traduisent pas toujours en actes. Solution plus légère : observer sur 3 jours au lieu de 5, avec une grille simplifiée à deux cases (fruit ou produit laitier : oui ou non), remplie par les animateurs pendant le goûter, ce qui prend quelques minutes par jour.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 9.3.2 – Construire les indicateurs

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les sept éléments d'un indicateur complet.
2. Citez trois qualités d'un bon indicateur.
3. Pourquoi faut-il toujours préciser le dénominateur d'un pourcentage ?
4. La valeur initiale est de 40 %. On vise une réduction relative d'un quart. Quelle est la cible ?
5. 12 participants sur 40 ont le comportement visé au départ ; la cible est 55 %. Combien de participants doivent l'avoir à la fin ?
6. Pourquoi ne faut-il pas modifier la cible après avoir vu les résultats finaux ?

Corrigé – Point d'étape 9.3.2

1. Intitulé, mode de calcul, valeur initiale, valeur cible, source (outil), moment (fréquence), responsable.
2. Pertinent, fiable, sensible, faisable, compréhensible (trois au choix).
3. Parce qu'un même nombre n'a pas le même sens selon la population de référence (9 sur 12 répondants ou 9 sur 30 inscrits).
4. 40 × 0,75 = 30 %, soit une baisse de 10 points.
5. 0,55 × 40 = 22 participants, soit 10 de plus qu'au départ.
6. Parce que l'évaluation perdrait sa crédibilité : la cible doit être fixée avant, et toute révision justifiée et datée avant la mesure finale.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 9.3.3.
3 ou 4 sur 6	Je relis les qualités d'un indicateur et les calculs de cible.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 9.3.2 et je refais les exercices d'application.

9.3.3 Choisir les méthodes et les outils

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 9.2.2)

Les plans d'évaluation

Plan	Principe	Limite
Après seulement	Mesure à la fin	Aucun point de comparaison : on ne sait pas ce qui a changé
Avant / après	Même mesure au début et à la fin chez les mêmes personnes	On ne sait pas si le changement est dû à l'action (saisons, autres actions, désirabilité)
Avant / après avec groupe de comparaison	Comparer l'évolution des participants à celle d'un groupe similaire non bénéficiaire	Difficile à constituer ; éthique (priver d'action) ; groupes rarement comparables
Essai contrôlé randomisé	Tirage au sort des bénéficiaires	Méthode de référence de la recherche, rarement possible dans un projet de terrain
Méthodes qualitatives	Entretiens, groupes de parole, observation, photo- expression	Pas de généralisation chiffrée, mais compréhension des mécanismes
Méthodes mixtes	Combinaison quantitatif + qualitatif	Plus de temps ; c'est souvent le meilleur compromis

Les outils d'évaluation adaptés au public

Outil	Usage et adaptations
Feuille d'émargement	Présences (processus) ; codes anonymes si besoin
Questionnaire avant/après	Connaissances, comportements déclarés ; mêmes questions, même formulation, même code anonyme pour apparier les réponses (fiche F11)
Grille d'observation	Compétences réalisées en atelier (sait rincer et cuire les lentilles, sait lire le Nutri-Score)
Échelles imagées	Smileys, « météo », gommettes : enfants, personnes à littératie limitée (chapitre 5)
Cible ou « photolangage » d'évaluation	Évaluation collective et ludique en fin de séance
Entretien ou appel à distance	Maintien des changements à 1 ou 3 mois
Carnet de bord des animateurs	Écarts au conducteur, incidents, ajustements, observations
Indicateurs indirects	Ventes de légumes secs à l'épicerie ; recettes demandées ; inscriptions au cycle suivant

> **Astuce – Prévoir l'évaluation dès la conception**
>
> L'évaluation se prépare **avant** l'action : l'état initial doit être mesuré au premier atelier (ou pendant le diagnostic), sinon il n'y aura pas d'« avant ». Rédigez le **plan d'évaluation** (indicateurs, outils, calendrier, responsable) en même temps que les objectifs, et prévoyez dans le budget le temps de saisie et d'analyse.

Construire un questionnaire d'évaluation

Le questionnaire est l'outil le plus utilisé dans les projets de stage, et souvent le plus mal construit. Un bon questionnaire d'évaluation est **court** (une page, cinq minutes), **ciblé** sur les indicateurs du plan d'évaluation et **identique** avant et après.

Type de question	Exemple	Usage et précautions
Fermée à choix unique	« Prenez-vous un petit-déjeuner ? Jamais / 1 à 2 jours / 3 à 4 jours / 5 jours ou plus par semaine »	Facile à analyser ; prévoir des modalités qui ne se chevauchent pas et couvrent tous les cas
Fermée à choix multiples	« Qu'avez-vous mangé hier au goûter ? (plusieurs réponses possibles) »	Indiquer clairement que plusieurs réponses sont possibles
Échelle de Likert	« Je sais lire la liste des ingrédients : pas du tout d'accord… tout à fait d'accord »	Mesure une opinion ou un sentiment de compétence ; 4 ou 5 niveaux
Question de connaissance	« Parmi ces trois yaourts, lequel contient le moins de sucres ? » (avec photos des étiquettes)	Plus fiable qu'une auto-évaluation ; une seule bonne réponse, sans piège
Question ouverte	« Qu'avez-vous changé dans vos courses depuis le début des ateliers ? »	Riche mais longue à analyser ; une ou deux au plus

Méthode pas à pas – Construire et tester le questionnaire

1. Partir des indicateurs : chaque question correspond à un indicateur du plan d'évaluation ; une question qui ne sert à aucun indicateur est supprimée.

2. Rédiger simplement : phrases courtes, mots courants, une seule idée par question, pas de double négation.

3. Choisir des périodes de référence courtes : « la semaine dernière » plutôt que « en général » ou « le mois dernier » (biais de mémoire).

4. Ordonner : des questions faciles d'abord, les questions personnelles à la fin.

5. Adapter au public : pictogrammes, gros caractères, lecture à voix haute, traduction (chapitre 5).

6. Prétester auprès de trois à cinq personnes du public : comprennent-elles chaque question de la même façon ? combien de temps faut-il ?

7. Prévoir l'appariement : un code anonyme construit par la personne (par exemple les deux premières lettres du prénom de la mère et le jour de naissance).

Exemple – Une question améliorée après le prétest

Version de départ : « Mangez-vous suffisamment de fruits et légumes ? Oui / Non. » Au prétest, une participante répond « oui » en expliquant qu'elle mange « une pomme de temps en temps », une autre répond « non » alors qu'elle en mange à chaque repas, parce qu'elle « pourrait faire mieux ». La question mesure une **opinion**, pas une **consommation**. Version corrigée : « Hier, combien de portions de fruits et de légumes avez-vous mangées ? » avec des images de portions (une pomme, une assiette de haricots verts, un bol de soupe) et des cases 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou plus.

Attention – Le même questionnaire avant et après

Changer une seule formulation entre le premier et le second passage rend la comparaison discutable. Si une question s'est révélée mauvaise au premier passage, on le signale dans les limites plutôt que de la modifier en cours de route, ou l'on ajoute une nouvelle question sans supprimer l'ancienne.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.7

Corrigez les trois questions suivantes, prévues pour des adolescents d'une maison de quartier (projet fictif) : a) « Ne trouvez-vous pas que les sodas sont mauvais pour la santé ? » ; b) « Combien de fois par jour et par semaine buvez-vous des sodas et des jus ? » ; c) « Quelle est votre consommation de glucides simples ? ».

Corrigé

a) Question **orientée** : « Que penses-tu des sodas ? » ou une échelle neutre « Les sodas sont bons pour la santé : pas du tout d'accord… tout à fait d'accord ». b) Question **double** et période floue : la séparer en deux questions (« Hier, combien de verres ou canettes de soda as-tu bus ? » puis la même pour les jus). c) Vocabulaire **technique** incompréhensible : « Hier, as-tu mangé ou bu ces produits ? » avec une liste illustrée (soda, bonbons, gâteau, céréales sucrées).

Population, échantillon et marge d'erreur

Quand le public est nombreux (tous les salariés d'une entreprise, tous les élèves d'un collège), on n'interroge souvent qu'une partie des personnes : un **échantillon**. Le résultat obtenu sur l'échantillon n'est alors qu'une **estimation** du résultat dans l'ensemble de la population, entourée d'une **marge d'erreur**.

Définition – Intervalle de confiance d'une proportion

Pour une proportion p observée sur un échantillon de n personnes tirées au hasard, l'intervalle de confiance à 95 % est approximativement $p \pm 1{,}96 \times \sqrt{p \times (1 - p) / n}$. Cela signifie que, si l'on répétait l'enquête de nombreuses fois, environ 95 % des intervalles ainsi calculés contiendraient la vraie valeur. La formule n'est valable que si l'échantillon est tiré au hasard et suffisamment grand (en pratique, $n \times p$ et $n \times (1 - p)$ au moins égaux à 5).

Exemple – Calcul détaillé : la marge d'erreur selon la taille de l'échantillon

Dans une entreprise (fictive), 45 % des salariés interrogés déclarent sauter le déjeuner au moins une fois par semaine. Avec **120 répondants** : marge = $1{,}96 \times \sqrt{0{,}45 \times 0{,}55 / 120} = 1{,}96 \times \sqrt{0{,}002063} = 1{,}96 \times 0{,}0454 =$ **0,089**, soit **± 8,9 points** ; intervalle **36,1 % à 53,9 %**. Avec seulement **30 répondants** : marge = $1{,}96 \times \sqrt{0{,}45 \times 0{,}55 / 30}$ = **0,178**, soit **± 17,8 points** ; intervalle **27,2 % à 62,8 %**. Diviser l'échantillon par quatre double la marge d'erreur.

Taille de l'échantillon	Marge d'erreur maximale (p = 50 %)
30	± 17,9 points
100	± 9,8 points
400	± 4,9 points

Pour obtenir une marge de ± 10 points dans le cas le plus défavorable (p = 50 %), il faut environ $1{,}96^2 \times 0{,}25 / 0{,}10^2 =$ **96** répondants ; pour ± 5 points, environ **385**. C'est pourquoi un projet de stage, qui porte souvent sur 10 à 40 personnes, doit présenter ses résultats avec prudence et toujours avec les effectifs.

Attention – Un échantillon de volontaires n'est pas tiré au hasard

La formule suppose un tirage au hasard. Un questionnaire déposé à l'accueil et rempli par les volontaires donne un échantillon **biaisé** : les personnes les plus intéressées répondent davantage. La marge calculée sous-estime alors l'incertitude réelle. Dans ce cas, on décrit le profil des répondants et on compare, si possible, au profil de l'ensemble du public (âge, sexe, service, quartier).

Le taux de réponse

Le **taux de réponse** (répondants / personnes sollicitées × 100) renseigne sur la représentativité. Au-dessous d'environ 50 %, le risque que les répondants soient différents des non-répondants devient important. Pour

l'améliorer : questionnaire court, temps dédié pendant la séance, relance, recueil par une personne de confiance, version papier et version numérique.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.8

Dans un lycée (établissement fictif), 13 élèves sur 40 interrogés au hasard déclarent ne rien manger avant 10 h. a) Calculez la proportion et la marge d'erreur à 95 %. b) Donnez l'intervalle. c) Le proviseur affirme que « un tiers exactement des élèves du lycée ne mangent rien le matin ». Commentez.

Corrigé

a) p = 13 / 40 = **0,325**, soit 32,5 % ; marge = 1,96 × √(0,325 × 0,675 / 40) = 1,96 × 0,0741 = **0,145**, soit **± 14,5 points**. b) Intervalle : **18,0 % à 47,0 %**. c) L'affirmation est trop précise : avec 40 élèves, la proportion réelle se situe probablement entre environ un cinquième et un peu moins de la moitié des élèves. On peut dire « environ un élève sur trois parmi les élèves interrogés », en donnant l'effectif.

Observer les comportements plutôt que les déclarer

Les questionnaires mesurent ce que les personnes **disent** faire. Quand c'est possible, on complète par des mesures de ce qu'elles **font** : ces données sont moins sensibles à la désirabilité sociale.

Méthode	Principe	Atouts	Limites
Pesée des restes	Peser ce qui reste dans les assiettes, rapporter au nombre de repas	Objective, chiffrée	Matériel, temps, ne dit pas qui a mangé quoi
Estimation visuelle des restes	Noter pour chaque assiette la part restante (rien, un quart, la moitié, trois quarts, tout)	Rapide, sans balance	Moins précise ; former les observateurs
Photographie des plateaux	Photo avant et après le repas, analysée ensuite	Traçable, réanalysable	Accord des personnes, temps d'analyse
Données de vente	Ventes du distributeur, de la cafétéria, de l'épicerie	Disponibles, sur une longue période	Ne dit pas qui consomme ; dépend de l'offre
Observation des goûters ou des paniers repas	Grille remplie par les animateurs	Simple, adaptée aux enfants	Effet d'observation ; mêmes jours à comparer
Comptage	Remplissages de gourdes à la fontaine, participants à un marché	Facile	Mesure indirecte

Exemple – Calcul détaillé : estimation visuelle des restes de légumes

Dans un restaurant scolaire (fictif), une diététicienne observe 40 assiettes de légumes avant et après un cycle de dégustations. Elle attribue à chaque assiette la part restante : 0, ¼, ½, ¾ ou 1.

Part restante	0	¼	½	¾	1
Assiettes avant	10	12	8	6	4
Assiettes après	18	12	6	3	1

Avant : (10 × 0 + 12 × 0,25 + 8 × 0,5 + 6 × 0,75 + 4 × 1) / 40 = (0 + 3 + 4 + 4,5 + 4) / 40 = 15,5 / 40 = **38,8 %** de la portion laissée en moyenne. Après : (0 + 3 + 3 + 2,25 + 1) / 40 = 9,25 / 40 = **23,1 %**. Assiettes finies : 10 / 40 = **25,0 %** avant, 18 / 40 = **45,0 %** après. La part laissée baisse de 15,6 points ; il faut vérifier que le menu était comparable les deux jours (même légume, même préparation).

Astuce – Combiner une mesure déclarée et une mesure observée

Si le questionnaire indique une forte hausse de la consommation de légumes, mais que les restes ne baissent pas, la désirabilité sociale est probable. Si les deux mesures vont dans le même sens, la conclusion est plus solide. Cette **triangulation** est très appréciée du jury.

Attention – L'observation se prépare

Une observation n'est rigoureuse que si la **grille** est définie à l'avance, testée, et utilisée de la même façon par tous les observateurs. On choisit des jours comparables et l'on informe les personnes observées (éthique), sans leur indiquer ce que l'on espère voir changer.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.9

Un projet « Moins de sucre au bureau » (fictif) mesure son effet par les ventes du distributeur de l'entreprise. Citez deux avantages et trois limites de cet indicateur, puis proposez une mesure complémentaire.

Corrigé

Avantages : données disponibles sans effort, sur plusieurs mois, objectives. Limites : on ne sait pas **qui** achète (salariés participants ou non) ; les achats peuvent se reporter **ailleurs** (boulangerie, supermarché) ; les ventes dépendent de l'**offre** et des **prix** du distributeur, qui peuvent changer pendant le projet, et de l'effectif présent (congés). Mesure complémentaire : un court questionnaire apparié sur les consommations de la veille, ou le rapport des ventes au nombre de salariés présents.

Saisir et protéger les données

Les données recueillies doivent être **saisies**, **vérifiées** et **conservées** avec soin. Une erreur de saisie peut fausser un résultat ; une fuite de données peut porter atteinte aux personnes.

Méthode pas à pas – Organiser la saisie dans un tableur

1. Une ligne par personne (identifiée par son code anonyme), **une colonne par question**, avec un onglet « avant » et un onglet « après », ou deux colonnes par question.

2. Un dictionnaire des codes : 1 = oui, 0 = non, 9 = sans réponse ; pour une échelle, 1 à 5. On n'invente pas de réponse pour une case vide.

3. Des formules simples : NB.SI pour compter les « oui », MOYENNE et MEDIANE pour les scores, et une colonne « différence » (après − avant) pour les données appariées.

4. Un contrôle de saisie : ressaisir une partie des questionnaires (par exemple un sur cinq) et comparer ; vérifier les valeurs impossibles (score de 12 sur 10, âge de 3 ans dans un groupe d'adultes).

5. Un fichier de travail et un fichier d'origine : on ne modifie jamais le fichier d'origine.

Exemple – Une erreur de saisie qui change la conclusion

Dans un cycle de 15 participants (projet fictif), le score moyen après le cycle est d'abord calculé à 6,9 sur 10. En vérifiant, la stagiaire voit qu'un score de 4 a été saisi 40 : la somme des scores est fausse de 36 points. La vraie moyenne est (6,9 × 15 − 36) / 15 = (103,5 − 36) / 15 = 67,5 / 15 = **4,5** sur 10, alors que la moyenne avant était de 4,2. La « forte progression » annoncée disparaît. Un contrôle des valeurs minimales et maximales aurait repéré l'erreur immédiatement.

Protéger les données des participants

Le règlement général sur la protection des données (RGPD, applicable depuis le 25 mai 2018) s'applique aux questionnaires dès qu'une personne peut être identifiée, même indirectement. Pour un projet d'évaluation :

- ne recueillir que les données **nécessaires** aux indicateurs (minimisation) ;
- préférer les **codes anonymes** aux noms ; conserver séparément et peu de temps la liste qui relie les codes aux personnes (utile pour la mesure à distance) ;
- informer les personnes de l'usage de leurs réponses et de leurs droits ;
- protéger les fichiers (mot de passe, ordinateur de la structure plutôt qu'un ordinateur personnel ou une messagerie privée) ;
- traiter avec une prudence particulière les données de **santé** (poids, maladie), qui sont des données sensibles ; dans un projet de prévention, on s'en passe le plus souvent ;
- supprimer les données à la fin de la période prévue.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.10

Une stagiaire prévoit de faire figurer sur son questionnaire avant / après : nom, prénom, adresse, date de naissance, poids, taille et traitement médical des participants, « pour être complète ». Quelles données garder, lesquelles supprimer, et comment apparier les questionnaires ?

Corrigé

On supprime le nom, le prénom, l'adresse, le poids, la taille et le traitement médical : ils ne servent à aucun indicateur d'un projet de prévention et certains sont des données de santé. On peut garder une tranche d'âge (et non la date de naissance complète) si elle sert à décrire le public. L'appariement se fait par un **code anonyme** construit par le participant (par exemple les deux premières lettres du prénom de sa mère et son jour de naissance), écrit sur les deux questionnaires.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 9.3.3 – Choisir les méthodes et les outils

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez quatre plans d'évaluation, du moins au plus rigoureux.
2. Donnez trois règles de rédaction d'une question de questionnaire.
3. Pourquoi faut-il prétester un questionnaire ?
4. 60 % des 100 personnes interrogées au hasard sont satisfaites. Calculez la marge d'erreur à 95 %.
5. Citez deux méthodes qui observent les comportements au lieu de les déclarer.
6. Citez deux règles de protection des données dans un questionnaire d'évaluation.

Corrigé – Point d'étape 9.3.3

1. Après seulement ; avant / après ; avant / après avec groupe de comparaison ; essai contrôlé randomisé.
2. Une seule idée par question ; des mots simples ; une période de référence courte ; pas de question orientée ni de double négation (trois au choix).
3. Pour vérifier que le public comprend chaque question de la même façon et mesurer le temps nécessaire.
4. $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}60 \times 0{,}40 / 100)} = 1{,}96 \times 0{,}049 = 0{,}096$, soit ± 9,6 points (intervalle 50,4 % à 69,6 %).
5. Pesée ou estimation visuelle des restes, photographie des plateaux, observation des goûters, données de vente, comptages (deux au choix).
6. Minimisation des données, codes anonymes, information des personnes, protection des fichiers, suppression à la fin (deux au choix).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 9.3.4.
3 ou 4 sur 6	Je relis la construction du questionnaire et la marge d'erreur.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 9.3.3 et je refais les exercices d'application.

9.3.4 Analyser et interpréter les résultats

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 9.2.2)

Les calculs d'évaluation

Indicateur	Formule	Exemple (projet des Tilleuls)
Taux de réalisation	réalisé / prévu × 100	6 ateliers / 6 = 100 %
Taux de participation (présence)	présences / (séances × inscrits) × 100	58 / (6 × 12) = 58 / 72 = 80,6 %
Taux de couverture du public	participants / public cible × 100	12 familles / 85 familles de l'épicerie = 14,1 %
Taux d'atteinte d'un objectif	valeur obtenue / valeur cible × 100	75 % / 60 % = 125 %
Progression	après − avant (points)	75 − 25 = + 50 points
Gain normalisé	(après − avant) / (maximum − avant)	(7,17 − 4,75) / (10 − 4,75) = 0,46
Coût par participant	coût total / participants	3 590,90 / 12 = 299,24 €
Coût par résultat	coût total / nombre de personnes ayant atteint l'objectif	3 590,90 / 9 = 398,99 €

Exemple – Calcul détaillé : l'évaluation finale du projet des Tilleuls

Données : présences par atelier : 11, 10, 10, 9, 8, 10 ; scores de connaissances (/10) avant : 4, 5, 3, 6, 5, 4, 7, 5, 3, 6, 4, 5 ; après : 7, 8, 6, 8, 7, 6, 9, 7, 6, 8, 7, 7 ; légumes secs ≥ 2 fois par semaine : 3 familles avant, 9 après ; eau proposée au goûter : 4 avant, 8 après ; satisfaits ou très satisfaits : 11 sur 12 ; coût réalisé : 3 590,90 € (dont 3 092,90 € de dépenses monétaires). **Étape 1 – Processus** : présences 11 + 10 + 10 + 9 + 8 + 10 = **58** ; taux : 58 / 72 × 100 = **80,6 %** (cible ≥ 80 % : atteinte) ; ateliers 6 / 6 = **100 %** ; tendance : légère baisse aux ateliers 4 et 5 (vacances scolaires de printemps, enfants malades : causes à vérifier dans le carnet de bord). **Étape 2 – Connaissances** : moyenne avant 57 / 12 = **4,75** ; après 86 / 12 = **7,17** ; progression **+ 2,42 points** ; gain normalisé : 2,42 / (10 − 4,75) = 2,42 / 5,25 = **0,46**, soit 46 % de la marge de progression possible réalisée (gain « moyen » selon la classification de Hake : 0,3 à 0,7) ; taux d'atteinte de la cible (7/10) : 7,17 / 7 × 100 = **102,4 %**. **Étape 3 – Comportements** : légumes secs : 3 / 12 = **25 %** → 9 / 12 = **75 %**, soit **+ 50 points** ; taux d'atteinte : 75 / 60 × 100 = **125 %**. Eau au goûter : 4 / 12 = **33,3 %** → 8 / 12 = **66,7 %**, soit + 33,3 points (variation relative : (8 − 4) / 4 × 100 = **+ 100 %**, le nombre de familles a doublé). **Étape 4 – Satisfaction** : 11 / 12 × 100 = **91,7 %** (cible 85 %). **Étape 5 – Efficience** : coût par famille : 3 590,90 / 12 = **299,24 €** ; coût par famille ayant atteint l'objectif « légumes secs » : 3 590,90 / 9 = **398,99 €** ; en dépenses monétaires seulement : 3 092,90 / 9 = **343,66 €**. **Conclusion** : processus conforme ; objectifs spécifiques 1, 2 et 4 atteints ; satisfaction élevée ; coût cohérent avec un accompagnement intensif de 18 heures.

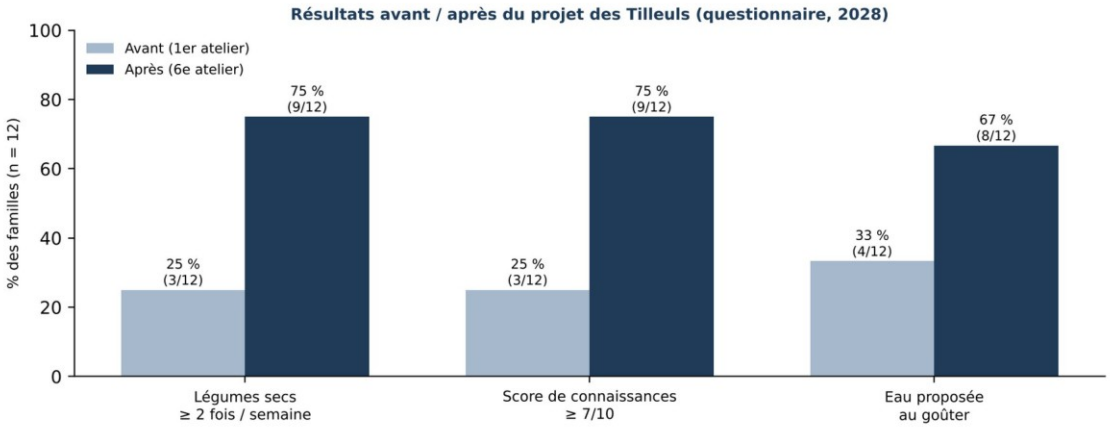


Figure 9.3 – Résultats avant / après du projet des Tilleuls

Comprendre le schéma – Figure 9.3

1. Le graphique en **barres groupées** compare, pour trois indicateurs, la situation **avant** (1er atelier) et **après** (6e atelier) chez les mêmes 12 familles.
2. Chaque barre indique le **pourcentage** et l'**effectif** (indispensable avec un petit groupe : 9/12).
3. La part des familles consommant des légumes secs au moins 2 fois par semaine **triple** (25 % → 75 %) ; celle des familles ayant au moins 7/10 au questionnaire triple aussi (3 → 9 familles) ; l'eau au goûter **double** (4 → 8 familles).
4. Ce graphique **décrit** une évolution ; il ne **prouve** pas que l'action en est la seule cause (voir les limites).

Interpréter avec prudence : les limites

Limite	Explication et parade
Petit effectif	12 familles : une famille = 8,3 points ; présenter les effectifs, éviter les décimales inutiles, ne pas généraliser
Données déclaratives	Désirabilité sociale (on déclare ce que l'animateur attend) : compléter par des observations (recettes réalisées), des indicateurs indirects (ventes de l'épicerie)
Absence de groupe de comparaison	D'autres facteurs ont pu jouer (campagne nationale, saison) ; comparer si possible à des familles non participantes de l'épicerie
Effet d'apprentissage du questionnaire	Les participants retiennent les questions du premier passage ; varier légèrement la forme ou mesurer par l'observation
Biais de sélection	Les familles volontaires sont souvent les plus motivées ; décrire leur profil
Perdus de vue	Les personnes absentes au dernier atelier ne remplissent pas le questionnaire « après » ; préciser le nombre de questionnaires appariés
Court terme	Mesure à la fin du cycle : prévoir un recueil à distance (3 mois) pour le maintien
Effet Hawthorne	Le fait d'être observé et accompagné modifie les comportements

Méthode pas à pas – Rédiger une interprétation : la règle des 4 temps

1. Constater : « La part des familles consommant des légumes secs au moins 2 fois par semaine est passée de 3 à 9 familles sur 12 (25 % à 75 %). »

2. Comparer à l'objectif : « L'objectif de 60 % est dépassé (taux d'atteinte : 125 %). »

3. Expliquer : « Trois ateliers sur six portaient sur les légumes secs, et l'épicerie a proposé des lentilles en vrac

à 3,60 €/kg. »

4. Nuancer : « Ces données sont déclaratives et portent sur 12 familles volontaires, sans groupe de comparaison ; un appel à 3 mois vérifiera le maintien. »

Le modèle RE-AIM : évaluer la portée réelle

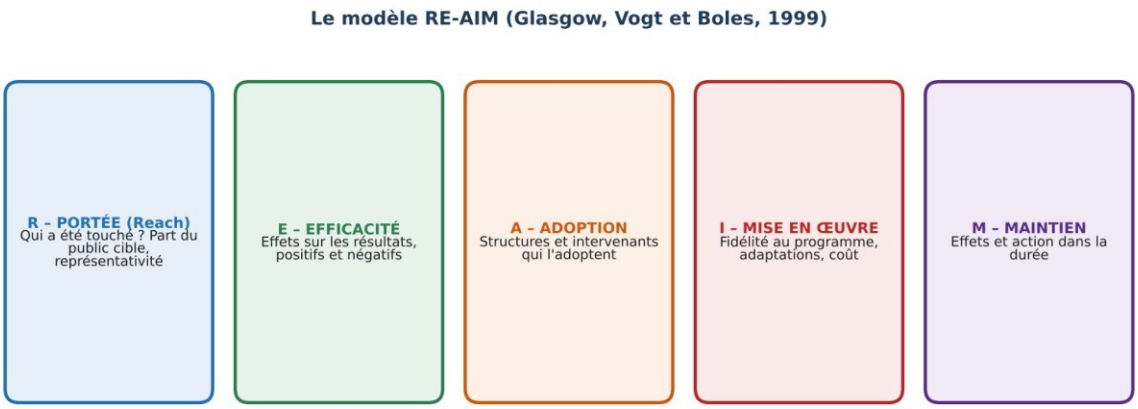


Figure 9.4 – Le modèle RE-AIM

Comprendre le schéma – Figure 9.4

1. R – Portée (*Reach*) : combien de personnes du public cible ont été touchées, et sont-elles représentatives ? Exemple : 12 familles sur 85 inscrites à l'épicerie (14,1 %), dont 9 monoparentales (75 %, contre 28 % dans le quartier : le projet a bien touché des familles prioritaires).

2. E – Efficacité : effets sur les résultats (connaissances, comportements), y compris les effets **négatifs** (une famille s'est sentie jugée lors d'un échange sur les sodas).

3. A – Adoption : combien de structures ou d'intervenants adoptent l'action (le centre social voisin demande les conducteurs).

4. I – Mise en œuvre (*Implementation*) : fidélité au programme prévu, adaptations, coût.

5. M – Maintien : maintien des effets chez les participants et de l'action dans la structure.

6. Ce modèle (Glasgow, Vogt et Boles, 1999) rappelle qu'une action très efficace mais qui touche peu de personnes, ou qui ne dure pas, a un intérêt limité en santé publique.

Décrire des résultats : moyenne, médiane, étendue

Avant d'interpréter, on **décrit** les données. Avec les petits effectifs d'un projet de stage, quelques indicateurs simples suffisent, à condition de les choisir avec discernement.

Indicateur	Calcul	Quand l'utiliser
Effectif et pourcentage	n ; n / total × 100	Variables oui / non ou en catégories ; toujours donner l'effectif
Moyenne	somme des valeurs / nombre de valeurs	Scores, quantités, quand il n'y a pas de valeur extrême
Médiane	valeur du milieu quand on range les valeurs par ordre croissant	Quand quelques valeurs extrêmes faussent la moyenne
Étendue	valeur maximale − valeur minimale	Pour montrer la dispersion des réponses

Indicateur	Calcul	Quand l'utiliser
Différences individuelles	après − avant pour chaque personne	Données appariées : combien ont progressé, stagné, régressé

Exemple – Calcul détaillé : portions de fruits et légumes déclarées par 11 participants

Un groupe de 11 adultes (projet fictif) indique le nombre de portions de fruits et légumes mangées la veille, au premier et au dernier atelier.

Code	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11
Avant	1	2	0	3	2	1	5	2	1	0	2
Après	3	3	1	4	2	2	5	3	2	1	3

- Moyennes : avant 19 / 11 = **1,7** portion ; après 29 / 11 = **2,6** portions ; progression moyenne **+ 0,9** portion.
- Médianes : valeurs avant rangées 0, 0, 1, 1, 1, **2**, 2, 2, 2, 3, 5 : médiane **2** ; après 1, 1, 2, 2, 2, **3**, 3, 3, 3, 4, 5 : médiane **3**.
- Étendue : 5 − 0 = **5** avant ; 5 − 1 = **4** après.
- Différences individuelles : 9 participants ont progressé (de 1 ou 2 portions), 2 sont restés stables (P5 et P7), aucun n'a régressé.
- Participants qui atteignent au moins 3 portions : **2** sur 11 avant, **6** sur 11 après.

Lecture : la progression est générale mais modeste ; la moyenne de 2,6 portions reste loin du repère d'au moins cinq fruits et légumes par jour. Présenter les deux résultats (progression et distance au repère) est plus honnête que de ne retenir que la progression.

Astuce – Arrondir intelligemment

Avec 11 personnes, une personne représente 9,1 points : écrire « 54,545 % » donne une fausse impression de précision. On arrondit les pourcentages à l'unité (ou à une décimale dans un calcul intermédiaire) et l'on écrit toujours l'effectif : « 6 participants sur 11 (55 %) ». Pour les moyennes, une décimale suffit le plus souvent.

Attention – Une moyenne peut cacher des situations très différentes

Une moyenne de 2,6 portions peut correspondre à un groupe homogène (tout le monde autour de 2 ou 3) ou à un groupe partagé (certains à 0, d'autres à 5). La médiane, l'étendue et surtout la **répartition** (combien de personnes à chaque niveau) complètent utilement la moyenne.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.11

Les durées d'activité physique déclarées la veille (en minutes) par 7 retraités sont : 0, 20, 25, 30, 30, 35, 180. a) Calculez la moyenne et la médiane. b) Laquelle décrit le mieux le groupe ? Pourquoi ?

Corrigé

a) Moyenne : (0 + 20 + 25 + 30 + 30 + 35 + 180) / 7 = 320 / 7 = **45,7 minutes** ; médiane (4e valeur) : **30 minutes**. b) La **médiane** décrit mieux le groupe : la moyenne est tirée vers le haut par une seule valeur extrême (180 minutes, peut-être une randonnée exceptionnelle) ; six retraités sur sept ont fait 35 minutes ou moins.

Le test de McNemar : la méthode au niveau BTS

Quand une variable oui / non est mesurée **chez les mêmes personnes** avant et après, le test de **McNemar** permet de savoir si l'évolution observée peut s'expliquer par le hasard. Il n'utilise que les personnes qui ont **changé** : celles qui sont passées de « non » à « oui » (progression, effectif c) et celles qui sont passées de « oui » à « non » (régression, effectif b).

Méthode pas à pas – Appliquer le test de McNemar

1. Construire le tableau de transition (9.3.7) et repérer b (oui → non) et c (non → oui).

2. Vérifier la condition : le test donne un résultat fiable si b + c est au moins égal à 10. Sinon, on le signale (ou l'on utilise le test exact, niveau L3, 9.5).

3. Calculer la statistique avec correction de continuité : $\chi^2 = (|b - c| - 1)^2 / (b + c)$.

4. Comparer à 3,84 (seuil au risque de 5 % pour 1 degré de liberté) : si χ^2 est supérieur à 3,84, l'évolution est dite **statistiquement significative**.

5. Conclure avec prudence : significatif veut dire « peu probable d'être dû au hasard », pas « dû à l'action ».

Exemple – Calcul détaillé : deux situations

Situation 1 : dans un groupe de 30 salariés (projet fictif), 3 personnes sont passées de « oui » à « non » (b = 3) et 12 de « non » à « oui » (c = 12). b + c = 15, au moins égal à 10 : le test est utilisable. $\chi^2 = (|3 - 12| - 1)^2 / (3 + 12) = 8^2 / 15 = 64 / 15 =$ **4,27**, supérieur à 3,84 : l'évolution est **significative** au risque de 5 %.

Situation 2 : dans un groupe de 14 parents, b = 2 et c = 7. b + c = 9 : le test est **peu fiable**. À titre indicatif, $\chi^2 = (|2 - 7| - 1)^2 / 9 = 16 / 9 =$ **1,78**, inférieur à 3,84 : on ne peut pas conclure que l'évolution dépasse ce que le hasard pourrait produire. On écrit : « 7 parents ont adopté le comportement et 2 l'ont abandonné ; l'effectif est trop faible pour conclure statistiquement. »

Attention – Pas significatif ne veut pas dire inefficace

Avec un petit groupe, une vraie amélioration peut ne pas être significative : le test manque de **puissance**. On ne conclut donc pas « l'action n'a servi à rien », mais « l'effectif ne permet pas de conclure ». À l'inverse, un résultat significatif sans groupe de comparaison peut venir d'autres facteurs (saison, campagne nationale).

Rédiger le résultat d'un test

Un résultat de test se rédige en une ou deux phrases qui donnent les effectifs, la valeur calculée, le seuil et la conclusion. Exemple : « Entre le début et la fin du cycle, 12 salariés ont commencé à prendre un déjeuner assis et 3 ont arrêté ; le test de McNemar ($\chi^2 = 4,27$, supérieur à 3,84) montre que cette évolution est statistiquement significative au risque de 5 %. Sans groupe de comparaison, elle ne peut cependant pas être attribuée avec certitude au projet. »

À vous de jouer – Exercice d'application 9.12

Dans un groupe de 26 adolescents (projet fictif), 4 ont arrêté de prendre un petit-déjeuner et 14 ont commencé à en prendre un. a) Le test de McNemar est-il utilisable ? b) Calculez χ^2 et concluez. c) Rédigez la phrase de résultat.

Corrigé

a) b + c = 4 + 14 = 18, au moins égal à 10 : oui. b) $\chi^2 = (|4 - 14| - 1)^2 / 18 = 81 / 18 =$ **4,50**, supérieur à 3,84 : évolution significative au risque de 5 %. c) « 14 adolescents ont commencé à prendre un petit-déjeuner et 4 ont arrêté ; cette évolution est statistiquement significative (test de McNemar, $\chi^2 = 4,50$). L'absence de

groupe de comparaison invite à la prudence sur la part due au projet. »

Comparer avec un groupe qui n'a pas bénéficié de l'action

Un avant / après montre une **évolution**. Pour savoir quelle part de cette évolution revient à l'action, il faut savoir ce qui se serait passé sans elle. Un **groupe de comparaison** (des personnes semblables qui n'ont pas participé) donne une estimation de cette évolution « naturelle ».

Définition – Différence des évolutions

Différence des évolutions = (après − avant chez les participants) − (après − avant dans le groupe de comparaison). Elle estime l'effet propre de l'action, si les deux groupes sont comparables et ont été mesurés de la même façon. On l'appelle aussi « différence des différences ».

Exemple – Calcul détaillé : ateliers dans une commune, comparaison avec une commune voisine

Un programme d'ateliers pour seniors (fictif) mesure la part des personnes qui consomment un produit laitier à chaque repas. Participants : 18 sur 45 avant, 30 sur 45 après. Groupe de comparaison (seniors d'une commune voisine, non participants) : 16 sur 42 avant, 17 sur 42 après.

- Participants : 18 / 45 = **40,0 %** → 30 / 45 = **66,7 %**, soit **+ 26,7 points**.
- Comparaison : 16 / 42 = **38,1 %** → 17 / 42 = **40,5 %**, soit **+ 2,4 points**.
- Différence des évolutions : 26,7 − 2,4 = **24,3 points** : c'est l'estimation de l'effet propre des ateliers.
- Risque relatif après le programme : RR = 0,667 / 0,405 = **1,65**. Erreur type : √(1/30 − 1/45 + 1/17 − 1/42) = √0,0461 = 0,215 ; intervalle de confiance à 95 % : exp(ln 1,65 ± 1,96 × 0,215) = exp(0,499 ± 0,421), soit **[1,08 ; 2,51]**. L'intervalle ne contient pas 1 : la différence en fin de programme est statistiquement significative.
- Les deux groupes partaient d'un niveau proche (40,0 % et 38,1 %), ce qui renforce la comparaison.

Condition	Pourquoi
Groupes semblables au départ	Âge, sexe, revenus, situation de départ proches ; sinon la différence peut venir des groupes eux-mêmes
Mêmes mesures, mêmes moments	Même questionnaire, mêmes dates, même mode de passation
Pas d'autre action dans un seul des groupes	Sinon on mesure l'effet de cette autre action
Même recrutement	Des volontaires d'un côté et des personnes tirées au sort de l'autre ne sont pas comparables
Respect de l'éthique	Le groupe de comparaison peut bénéficier de l'action plus tard (liste d'attente)

Astuce – Le groupe « liste d'attente »

Quand il y a plus de demandes que de places, les personnes qui commenceront au cycle suivant forment un groupe de comparaison naturel : elles remplissent le questionnaire aux mêmes dates que le premier groupe, puis bénéficient de l'action. Personne n'est privé de l'action, et l'évaluation gagne en rigueur.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.13

Dans une école (fictive), la part des élèves qui apportent un fruit à la récréation passe de 22 % à 48 % dans les classes participantes, et de 20 % à 31 % dans les classes d'une autre école du même quartier. a) Calculez les deux évolutions et la différence des évolutions. b) Interprétez. c) Citez deux vérifications à faire avant de conclure.

Corrigé

a) Participants : 48 − 22 = **+ 26 points** ; comparaison : 31 − 20 = **+ 11 points** ; différence des évolutions : 26 − 11 = **15 points**. b) Une partie de l'évolution (11 points) se retrouve sans l'action (saison des fruits, campagne nationale, effet de mode) ; l'effet propre estimé du projet est d'environ 15 points. c) Vérifier que les élèves des deux écoles sont comparables (âge, milieu social, offre de la cantine) et que les mesures ont été faites aux mêmes dates avec la même grille ; vérifier aussi les effectifs.

Choisir le bon graphique

Un graphique bien choisi fait comprendre un résultat en quelques secondes ; un graphique mal choisi le déforme. Dans un dossier ou un bilan, chaque graphique doit avoir un **titre**, des **axes nommés**, les **effectifs**, la **source** et la **date**, et une phrase de commentaire.

Ce que l'on veut montrer	Graphique adapté	À éviter
Une évolution avant / après pour quelques indicateurs	Barres groupées (avant et après côte à côte)	Deux camemberts à comparer
Une évolution dans le temps (présences par séance)	Courbe ou barres dans l'ordre chronologique	Barres triées par valeur
La répartition d'un tout en peu de catégories	Barres horizontales, ou secteurs si 2 à 4 catégories	Secteurs en 3D, plus de 5 secteurs
La comparaison entre sous-groupes	Barres groupées par sous-groupe	Graphique empilé difficile à lire
Des réponses à une échelle de Likert	Barre horizontale empilée à 100 %, du « pas du tout » au « tout à fait »	Moyenne seule d'une échelle

Méthode pas à pas – Contrôler un graphique avant de le publier

1. **L'axe des barres part-il de zéro ?** Sinon, les différences sont visuellement exagérées.
2. **Les effectifs sont-ils indiqués** (« n = 12 ») ?
3. **Le titre dit-il ce que l'on voit** (« Part des familles qui cuisinent des légumes secs au moins deux fois par semaine, avant et après le cycle ») ?
4. **Les couleurs sont-elles lisibles** en noir et blanc et par une personne daltonienne (éviter rouge et vert seuls) ?
5. **La source et la date** figurent-elles sous le graphique ?
6. **Une phrase de commentaire** accompagne-t-elle le graphique, sans le paraphraser ?

Exemple – Le facteur de déformation d'un axe tronqué

Une présentation montre la satisfaction : 78 % en 2026, 84 % en 2027, avec un axe qui commence à 75 %. Les barres mesurent 3 et 9 unités : la barre de 2027 paraît **trois fois** plus haute. L'évolution réelle est de (84 − 78) / 78 × 100 = **+ 7,7 %** (+ 6 points) ; l'évolution suggérée par les barres est de (9 − 3) / 3 × 100 = **+ 200 %**. Le graphique exagère l'évolution 200 / 7,7 = environ **26 fois**. Avec un axe de 0 à 100 %, les deux barres paraissent presque égales, ce qui correspond à la réalité.

Attention – Un graphique ne remplace pas l'interprétation

Le jury attend une phrase qui dit ce que montre le graphique, la compare à la cible et la nuance : « La part des familles qui cuisinent des légumes secs passe de 3 à 9 familles sur 12 ; la cible de 60 % est dépassée, mais ces

données sont déclaratives. » Un graphique laissé sans commentaire est souvent considéré comme non exploité.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.14

Pour chacune des données suivantes, choisissez un graphique et justifiez : a) les présences aux 8 séances d'un cycle ; b) la part de participants qui atteignent trois objectifs, avant et après ; c) les réponses de 40 participants à l'affirmation « Je me sens capable de cuisiner un plat de légumes » (5 niveaux d'accord).

Corrigé

a) Une **courbe** ou des barres dans l'ordre des séances : on voit l'évolution de la participation dans le temps (baisse éventuelle pendant les vacances). b) Des **barres groupées** (avant et après pour chaque objectif), avec axe de 0 à 100 % et effectifs. c) Une **barre horizontale empilée à 100 %** avant et une après, du « pas du tout d'accord » au « tout à fait d'accord » : on voit la répartition et son déplacement vers l'accord.

Passer des résultats au jugement : la grille de jugement

Évaluer, c'est **juger**. Les résultats chiffrés ne suffisent pas : il faut dire, pour chaque critère, si le résultat est satisfaisant ou non, en fonction de **seuils fixés à l'avance**. La **grille de jugement** rend ce passage explicite et évite un jugement « au ressenti ».

Méthode pas à pas – Construire une grille de jugement

1. **Lister les critères** retenus (efficacité, efficience, participation, satisfaction, équité, durabilité).
2. **Associer un ou deux indicateurs** à chaque critère, avec la cible.
3. **Fixer les seuils** avant de voir les résultats, par exemple : « atteint » si le résultat est au moins égal à la cible ; « partiellement atteint » s'il est entre 80 % et 100 % de la cible ; « non atteint » au-dessous.
4. **Reporter les résultats** et appliquer les seuils.
5. **Rédiger un jugement global** nuancé, qui ne se réduit pas à une moyenne des critères.

Exemple – La grille de jugement d'un projet en maison de quartier (données fictives)

Critère	Indicateur	Cible	Résultat	Taux d'atteinte	Jugement
Réalisation	Ateliers réalisés / prévus	10	10	100 %	Atteint
Participation	Taux de présence	75 %	68 %	90,7 %	Partiellement atteint
Efficacité (OS1)	Familles qui cuisinent un légume au dîner au moins 4 soirs sur 7	50 %	57 %	114 %	Atteint
Efficacité (OS2)	Enfants qui goûtent les légumes proposés	70 %	52 %	74,3 %	Non atteint
Efficience	Coût par famille	≤ 250 €	236 €	–	Atteint
Équité	Part des familles du quartier prioritaire parmi les participantes	≥ 50 %	46 %	92 %	Partiellement atteint

Taux d'atteinte : 68 / 75 × 100 = **90,7 %** ; 57 / 50 × 100 = **114 %** ; 52 / 70 × 100 = **74,3 %** ; 46 / 50 × 100 = **92 %**. Pour le coût, la cible est un **maximum** : 236 € est inférieur à 250 €, la cible est respectée.

Jugement global : le projet a été réalisé comme prévu et atteint son objectif principal auprès des parents, pour un coût conforme. L'objectif concernant les enfants n'est pas atteint : les dégustations ont été trop peu

nombreuses (deux sur dix ateliers). La participation et l'équité sont proches des cibles. Recommandation : maintenir le projet en renforçant les dégustations avec les enfants et le recrutement dans le quartier prioritaire.

Attention – Une cible « maximum » ou « minimum »

Pour un coût, un taux d'abandon ou une quantité de restes, la cible est un **plafond** : le résultat est bon s'il est **inférieur** à la cible. Calculer un « taux d'atteinte » de 236 / 250 = 94,4 % et conclure « partiellement atteint » serait un contresens. On indique simplement si le plafond est respecté.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.15

Un projet visait un taux de présence d'au moins 80 % (résultat : 71 %), une satisfaction d'au moins 85 % (résultat : 92 %) et un gaspillage d'au plus 60 g par repas (résultat : 66 g). Avec les seuils de la méthode ci-dessus, jugez chaque critère.

Corrigé

Présence : 71 / 80 × 100 = **88,8 %** de la cible : **partiellement atteint**. Satisfaction : 92 / 85 × 100 = **108,2 %** : **atteint**. Gaspillage : la cible est un plafond ; 66 g dépasse 60 g de 6 g, soit 10 % de plus que le plafond : **non atteint** (on peut le dire « proche » si des seuils l'ont prévu). Le jugement global doit préciser les causes possibles et les ajustements.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 9.3.4 – Analyser et interpréter

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quand faut-il préférer la médiane à la moyenne ?
2. Donnez la formule du test de McNemar et sa condition d'utilisation.
3. b = 5, c = 15. Calculez χ^2 et concluez.
4. Participants : + 20 points ; groupe de comparaison : + 8 points. Quelle est la différence des évolutions et que signifie-t-elle ?
5. Citez trois vérifications à faire avant de publier un graphique.
6. Le coût par participant est de 180 € pour un plafond de 200 €. Le critère est-il atteint ?

Corrigé – Point d'étape 9.3.4

1. Quand quelques valeurs extrêmes tirent la moyenne vers le haut ou vers le bas.
2. $\chi^2 = (|b - c| - 1)^2 / (b + c)$, comparé à 3,84 au risque de 5 % ; fiable si b + c est au moins égal à 10.
3. $\chi^2 = (10 - 1)^2 / 20 = 81 / 20 = 4{,}05$, supérieur à 3,84 : évolution significative au risque de 5 %.
4. 20 − 8 = 12 points : c'est l'estimation de l'effet propre de l'action, si les groupes sont comparables.
5. Axe à zéro, effectifs, titre explicite, source et date, couleurs lisibles, commentaire (trois au choix).
6. Oui : la cible est un plafond et 180 € est inférieur à 200 €.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 9.3.5.
3 ou 4 sur 6	Je refais les calculs de McNemar et de différence des évolutions.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 9.3.4 et je refais les exercices d'application.

9.3.5 Valoriser le projet

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 ; p. 108 et 109 · CNED : Essentiels M1 S2 §2 (p. 11 et 12)

Définition – Valorisation

Ensemble des actions qui permettent de **faire connaître** le projet et ses résultats, de les **restituer** aux personnes concernées, d'en **rendre compte** aux financeurs et partenaires et d'en **tirer des enseignements** utiles à d'autres (capitalisation), en vue de sa poursuite ou de son extension.

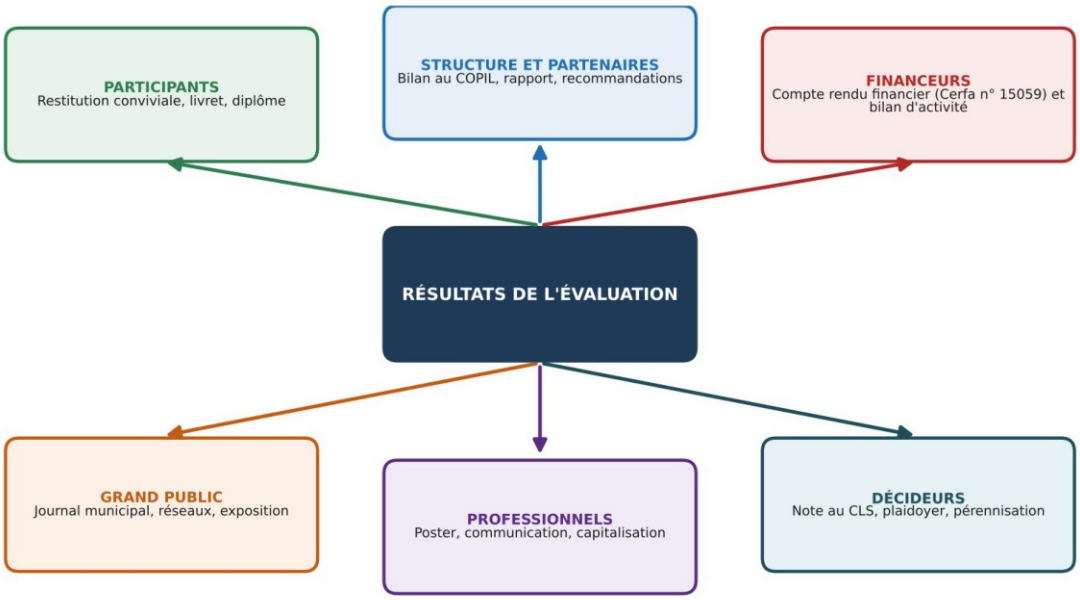


Figure 9.5 – Valoriser auprès de chaque destinataire

Destinataire	Ce qu'il attend	Support
Participants	Reconnaissance, résultats compréhensibles, suite	Temps fort convivial, livret de recettes, attestation de participation, résultats en images
Structure, partenaires	Bilan, recommandations, perspectives	Rapport synthétique (5 à 10 pages), présentation au COPIL
Financeurs	Utilisation de la subvention, atteinte des objectifs	Compte rendu financier (formulaire Cerfa n° 15059 pour les subventions aux associations) et bilan qualitatif, dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice
Grand public, habitants	Information, envie de participer	Article du journal municipal, affiche, publication sur les réseaux de la structure (avec autorisations, chapitre 6)
Professionnels	Méthode, outils, résultats, limites	Poster, communication orale, fiche de capitalisation, article dans une revue professionnelle
Décideurs	Arguments pour pérenniser ou étendre	Note de synthèse d'une page pour le CLS ou les élus, chiffres-clés

Méthode pas à pas – Réaliser un poster professionnel

Format A0 ou A1, lisible à 1,5 mètre. Structure : **titre** court et attractif, auteurs et structure, **contexte** (2 chiffres), **objectifs**, **méthode** (public, actions, évaluation), **résultats** (1 ou 2 graphiques, chiffres-clés en grand), **discussion** (limites, perspectives), logos des partenaires et financeurs, contact. Règle : 70 % d'images et de

graphiques, 30 % de texte ; police d'au moins 24 points pour le texte.

Pérenniser, transférer, capitaliser

Notion	Définition et pistes
Pérennisation	Maintien de l'action ou de ses effets après la fin du financement initial : relais formés, intégration au projet de la structure, financements pluriannuels, outils réutilisables, inscription dans le CLS ou le PAT
Transférabilité	Capacité d'une action à produire des effets similaires dans un autre contexte ; elle dépend de fonctions clés à conserver (participation des familles, recettes à petit prix, partenariat avec l'épicerie) et d'éléments adaptables (recettes, horaires). La grille ASTAIRE (Cambon et coll., 2013) aide à analyser la transférabilité
Capitalisation	Transformation de l'expérience en connaissance partageable : ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi, conditions de réussite ; en France, la démarche de capitalisation des expériences en promotion de la santé (portail CAPS, Société française de santé publique et partenaires) diffuse des fiches d'expériences

Le compte rendu financier de subvention

Une subvention publique s'accompagne d'une obligation : **rendre compte** de son utilisation. Pour les associations, le compte rendu financier prend la forme du formulaire **Cerfa n° 15059** (vérifiez la version en vigueur sur *service-public.fr*). Il est transmis au financeur dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice au cours duquel la subvention a été accordée, sauf disposition différente de la convention.

Partie du compte rendu	Contenu
Bilan qualitatif de l'action	Ce qui a été réalisé, le public touché, les résultats au regard des objectifs, les écarts avec le projet initial
Tableau de synthèse	Charges et produits **prévus** et **réalisés**, poste par poste, y compris les contributions volontaires en nature
Annexe explicative	Explication des écarts significatifs, règles de répartition des charges indirectes, mode de valorisation des contributions en nature

Exemple – Calcul détaillé : le tableau prévu / réalisé d'un projet associatif

Une association (fictive) a reçu une subvention forfaitaire de 4 000 € pour un projet prévu à 10 000 €. La convention précise : « Si les dépenses réalisées sont inférieures à 90 % des dépenses prévues, la subvention est réduite au prorata. » La subvention a été versée en totalité à la signature.

Poste	Prévu (€)	Réalisé (€)	Écart (€)	Écart (%)
Achats (denrées, petit matériel)	3 200	3 050	− 150	− 4,7 %
Services extérieurs (diététicienne)	4 400	3 520	− 880	− 20,0 %
Communication	900	640	− 260	− 28,9 %
Déplacements	500	390	− 110	− 22,0 %
Charges de personnel	1 000	1 000	0	0,0 %
Total	10 000	8 600	− 1 400	− 14,0 %

- Taux de réalisation : 8 600 / 10 000 × 100 = **86,0 %**, inférieur à 90 % : la clause s'applique.
- Subvention due : 4 000 × 0,86 = **3 440 €** ; somme à reverser : 4 000 − 3 440 = **560 €**.
- Les écarts de plus de 15 % (diététicienne, communication, déplacements) doivent être expliqués dans l'annexe (par exemple : deux ateliers annulés, affiches imprimées par la mairie, covoiturage).

- Les contributions volontaires en nature (par exemple 120 heures de bénévolat valorisées à 12 € de l'heure, taux retenu par l'association, soit 1 440 €) figurent dans des comptes à part et ne modifient pas le calcul de la subvention, sauf si la convention le prévoit.

Attention – Prévenir avant, pas après

Toute modification importante du projet (annulation d'ateliers, changement de public, report) doit être signalée **au moment où elle survient**, par écrit, au financeur. Celui-ci peut accepter un report, une réaffectation des fonds ou un avenant à la convention. Découvrir un écart au moment du compte rendu fragilise la relation de confiance et les demandes futures.

Astuce – Garder les justificatifs au fil du projet

Factures, feuilles d'émargement, relevés d'heures, comptes rendus de réunion : on les classe au fur et à mesure dans un dossier par poste budgétaire. Le compte rendu se remplit alors en quelques heures, et l'association peut répondre à un contrôle du financeur.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.16

Un projet prévu à 6 000 € a été réalisé à 5 700 €. La subvention de 3 000 € représentait au plus 50 % des dépenses réalisées ; 80 % ont été versés à la signature. a) Calculez le taux de réalisation. b) Calculez la subvention due, la somme déjà versée et le solde. c) Faut-il reverser de l'argent ?

Corrigé

a) 5 700 / 6 000 × 100 = **95,0 %**. b) Subvention due : 50 % × 5 700 = **2 850 €** ; déjà versé : 80 % × 3 000 = **2 400 €** ; solde à recevoir : 2 850 − 2 400 = **450 €** (au lieu de 600 €). c) Non : l'association a reçu moins que la subvention due ; le financeur verse un solde réduit de 150 €.

Écrire pour des décideurs et pour le grand public

Une même évaluation donne lieu à plusieurs écrits, très différents par leur longueur et leur ton. Deux écrits sont particulièrement demandés en fin de projet : la **note de synthèse** destinée à des décideurs (élus, direction, comité de pilotage) et l'**article ou communiqué** destiné au grand public.

	Note de synthèse pour décideurs	Article ou communiqué pour le grand public
But	Faire décider (poursuivre, financer, étendre)	Informer, donner envie, remercier
Longueur	Une page	1 500 à 3 000 signes
Contenu clé	Trois chiffres, le coût, une proposition, la décision demandée	Une histoire, un témoignage, un chiffre parlant, une date ou un contact
Ton	Factuel, précis	Concret, vivant, sans jargon
Pièges	Trop de détails méthodologiques	Chiffres sans effectif, photos sans autorisation, promesses de santé

Méthode pas à pas – Rédiger une note de synthèse d'une page

1. **Objet** : une ligne qui annonce la décision attendue (« Reconduction du programme… en 2028 »).
2. **Contexte** : trois lignes sur le problème et le projet.
3. **Résultats** : trois chiffres clés, avec effectifs et comparaison à la cible.

4. Coût : coût total, part du décideur, coût par participant.

5. Limites : une ou deux phrases honnêtes.

6. Proposition et décision demandée : ce que vous recommandez, chiffré, et ce que le décideur doit valider.

Exemple – Le premier paragraphe d'un article pour le bulletin municipal

« Mardi soir, la cuisine du centre social sent le curry de lentilles. Autour du plan de travail, huit parents découpent, goûtent, rient. Depuis janvier, 34 familles ont participé aux ateliers "Cuisiner malin" ; à la fin du cycle, 21 d'entre elles déclarent cuisiner des légumes secs chaque semaine, contre 9 au départ. "Mes enfants réclament maintenant le dahl du mardi", sourit une maman. Un nouveau cycle commence le 3 mars : inscriptions à l'accueil du centre social. » (exemple fictif)

Ce paragraphe donne une scène, un chiffre avec ses effectifs, un témoignage anonymisé et une information pratique. Il évite le vocabulaire technique et ne promet pas d'effet sur la santé.

Attention – Le communiqué n'est pas un bilan

Un article grand public ne présente pas toutes les limites de l'évaluation, mais il ne doit jamais **déformer** les résultats : pas de « les familles mangent désormais équilibré », pas de pourcentage sans effectif, pas de photo d'enfant sans l'accord écrit des parents. En cas de doute, faites relire par la structure.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.17

Le bilan d'un projet « Bien manger au travail » (fictif) indique : 48 salariés participants sur 160 ; part des participants qui déjeunent hors de leur poste : 35 % → 62 % ; coût total 5 400 €, dont 2 700 € pour l'entreprise ; la direction doit décider d'une deuxième année. Rédigez les rubriques « Résultats », « Coût » et « Décision demandée » de la note de synthèse.

Corrigé

Résultats : « 48 salariés sur 160 ont participé (30 %). Parmi eux, la part qui déjeune hors de son poste est passée de 35 % à 62 % (+ 27 points). » Coût : « 5 400 €, soit 112,50 € par participant ; la part de l'entreprise est de 2 700 €, soit 56,25 € par participant. » Décision demandée : « Reconduire le programme une deuxième année, pour 2 700 € à la charge de l'entreprise, en ciblant les équipes qui ont le moins participé. » Calculs : 48 / 160 = 30 % ; 5 400 / 48 = 112,50 € ; 2 700 / 48 = 56,25 €.

Restituer les résultats aux participants

La restitution aux participants est souvent oubliée, alors qu'elle est la plus importante sur le plan éthique : ce sont eux qui ont donné de leur temps, répondu aux questionnaires et fait l'effort de changer. Elle a aussi un intérêt pratique : les participants **complètent l'interprétation** (« si on n'est pas venus au 5e atelier, c'est à cause du ramadan ») et proposent des améliorations.

Format	Public adapté	Points de vigilance
Temps convivial avec affichage des résultats en images	Familles, enfants, personnes peu à l'aise avec l'écrit	Graphiques simples, pictogrammes, pas de jargon
Groupe de discussion « Voici ce que vous nous avez dit »	Adultes, salariés, étudiants	Laisser la parole, accepter les critiques
Courrier ou affiche récapitulative	Participants dispersés	Résultats collectifs uniquement
Livret de recettes ou d'astuces avec les résultats	Ateliers culinaires	Mettre en valeur les contributions des participants

Méthode pas à pas – Préparer une restitution respectueuse

1. Choisir trois à cinq résultats compréhensibles par tous, dont au moins une réussite collective.

2. Présenter les résultats du groupe, jamais de résultats individuels, et aucun sous-groupe de moins de cinq personnes.

3. Utiliser un langage positif, sans jugement (« vous êtes plus nombreux à… » plutôt que « encore trop de personnes ne… »).

4. Demander l'avis : « Est-ce que cela vous parle ? Qu'est-ce qui explique ce résultat selon vous ? »

5. Annoncer la suite : ce qui va changer grâce à leurs retours, la suite du projet, les relais possibles.

6. Remercier chacun, éventuellement avec une attestation de participation.

Exemple – Un résultat présenté de deux façons

Version maladroite : « 6 personnes sur 14 ne prennent toujours pas de petit-déjeuner, alors que c'était l'objectif principal. » Version respectueuse : « Au début, 4 personnes sur 14 prenaient un petit-déjeuner ; aujourd'hui, vous êtes 8. Ceux qui n'y arrivent pas encore nous ont parlé du manque de temps le matin : quelles idées avez-vous pour la suite ? » Les deux phrases donnent la même information, mais la seconde valorise le progrès et ouvre la discussion.

Attention – Les petits effectifs identifient les personnes

Dans un groupe de 12 personnes dont 2 hommes, écrire « les hommes ont moins progressé » désigne deux personnes précises. La règle pratique : on ne présente pas de résultat pour un sous-groupe de moins de cinq personnes, et l'on regroupe les catégories si nécessaire.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.18

Pour la restitution d'un cycle d'ateliers à des parents d'élèves (projet fictif), la stagiaire prévoit d'afficher un tableau avec le score de chaque parent au quiz, avant et après, et la phrase « Les parents du quartier des Peupliers ont moins progressé que les autres » (3 parents sur 15 habitent ce quartier). Relevez les problèmes et proposez une autre présentation.

Corrigé

Problèmes : des **résultats individuels** exposés à tous (atteinte à la confidentialité, risque d'humiliation) ; un **sous-groupe de 3 personnes**, facilement identifiables ; une formulation qui **stigmatise** un quartier. Présentation alternative : le score moyen du groupe avant et après, la part des parents qui ont progressé, un graphique simple ; chacun peut recevoir son propre score en privé s'il le souhaite ; la question des écarts entre quartiers est analysée dans le bilan interne, avec un regroupement plus large.

Préparer la pérennisation dès le bilan

Un projet de stage s'arrête souvent avec le départ du stagiaire ou la fin de la subvention. La **pérennisation** se prépare pourtant dès la conception, et le bilan est le bon moment pour proposer un **scénario de suite** précis. Le jury apprécie un stagiaire qui a pensé « après moi ».

Condition de pérennité	Question à se poser	Exemple de réponse
Portage	Qui portera l'action demain ?	La référente familles du centre social, avec deux parents relais formés

Condition de pérennité	Question à se poser	Exemple de réponse
Compétences	Les personnes qui reprennent savent-elles faire ?	Formation de 6 heures, conducteurs de séance et fiches recettes fournis
Financement	Qui paiera ?	Inscription dans le budget annuel de la structure ; demande pluriannuelle au contrat local de santé
Intégration	L'action fait-elle partie du projet de la structure ?	Ajout au projet social du centre ; calendrier annuel
Partenariats	Les partenaires restent-ils engagés ?	Convention renouvelée avec l'épicerie solidaire
Outils	Les outils sont-ils réutilisables ?	Kit d'animation, questionnaire d'évaluation, tableur de suivi
Demande du public	Les participants souhaitent-ils continuer ?	Liste d'attente pour le cycle suivant

Méthode pas à pas – Rédiger un scénario de pérennisation

1. Dire ce qui doit continuer : toute l'action, une partie (les « fonctions clés »), ou seulement les effets chez les participants.

2. Nommer les porteurs et leur rôle, avec leur accord.

3. Prévoir le transfert de compétences : formation, accompagnement des premières séances, outils.

4. Chiffrer le coût annuel de la suite et identifier les financements.

5. Fixer un calendrier et un indicateur de suivi (« deux cycles par an animés par l'équipe »).

6. Prévoir un point d'étape (par exemple à six mois) avec la structure.

Exemple – Calcul détaillé : le coût de la suite d'un projet

Le projet de stage a coûté 3 600 € pour un cycle de 8 ateliers, dont 1 200 € de temps de stagiaire et 900 € de conception des outils, qui ne sont plus à payer. Pour un cycle repris par l'équipe : denrées 640 €, diététicienne pour 2 ateliers sur 8 (2 × 3 h × 50 €) = **300 €**, temps de la référente (8 × 3 h × 24 €) = **576 €**, impression 120 €. Coût d'un cycle repris : 640 + 300 + 576 + 120 = **1 636 €**, soit 1 636 / 3 600 × 100 = **45,4 %** du coût du premier cycle. Deux cycles par an coûtent **3 272 €**. (données fictives)

Ce calcul montre au décideur que la suite coûte moins cher que le lancement, ce qui rend la pérennisation crédible.

Attention – Pérenniser n'est pas toujours souhaitable

Si l'évaluation montre une action peu efficace ou trop coûteuse, la bonne décision peut être de l'**arrêter** ou de la **transformer**. Pérenniser n'est pas un but en soi : c'est la suite logique d'une action qui a fait ses preuves et qui répond toujours à un besoin.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.19

Un projet « Petits-déjeuners partagés » dans un internat (fictif) a donné de bons résultats. La stagiaire part en juin. Proposez quatre éléments d'un scénario de pérennisation.

Corrigé

Exemples : la conseillère principale d'éducation et deux surveillants formés reprennent l'organisation (portage) ; des internes volontaires de première année sont formés comme « ambassadeurs » chaque rentrée

(compétences et renouvellement) ; le coût des denrées est intégré au budget du service de restauration, avec un appui demandé au conseil régional (financement) ; un kit (planning, fiches, questionnaire) est remis à l'équipe ; un bilan est fixé en janvier avec l'infirmière (point d'étape).

Transférer une action : la grille ASTAIRE en pratique

Une action qui a réussi quelque part donne envie de la reproduire ailleurs. Mais une action ne se transfère pas comme une recette : son efficacité dépend du contexte. La grille **ASTAIRE** (Cambon et coll., 2013) aide à analyser la transférabilité en examinant quatre dimensions.

Dimension	Questions à se poser	Exemples
Population	Le nouveau public a-t-il les mêmes besoins, les mêmes habitudes, les mêmes ressources ?	Familles jeunes ou retraités ; langue ; littératie ; revenus
Environnement	Le contexte local offre-t-il les mêmes conditions ?	Commerces, transports, équipements, politiques locales, partenaires
Mise en œuvre	Les intervenants, les méthodes et les moyens seront-ils équivalents ?	Formation des animateurs, durée des séances, budget
Accompagnement du transfert	Le transfert est-il accompagné ?	Formation par l'équipe d'origine, outils, échanges réguliers

Définition – Fonctions clés et éléments adaptables

Les **fonctions clés** sont les éléments qui produisent l'effet de l'action et qu'il faut conserver (par exemple : des séances pratiques plutôt qu'informatives, la participation du public au choix des contenus, un partenariat qui facilite l'accès aux aliments). Les **éléments adaptables** sont la forme que prennent ces fonctions dans un contexte donné (horaires, lieu, recettes, supports). Transférer, c'est garder les premières et adapter les seconds.

Exemple – Analyser le transfert d'un projet de la ville vers la campagne

Un projet urbain (fictif) d'ateliers culinaires pour parents, appuyé sur une épicerie solidaire du quartier, doit être transféré dans une communauté de communes rurale. **Population** : familles plus dispersées, davantage de familles avec un jardin ; les recettes de légumes de saison et de conservation conviennent. **Environnement** : pas d'épicerie solidaire, supermarché à 15 km, transport limité ; il faut trouver un autre partenaire pour l'accès (producteurs locaux, paniers solidaires) et organiser des ateliers itinérants dans plusieurs salles des fêtes. **Mise en œuvre** : l'animatrice du centre social rural doit être formée ; le budget doit inclure les déplacements. **Accompagnement** : deux ateliers co-animés avec l'équipe d'origine, puis un échange par trimestre. **Fonction clé menacée** : le partenariat qui facilite l'accès aux aliments ; sans solution, l'action risque de perdre son efficacité.

Attention – Une réussite n'est pas une preuve universelle

Un projet qui a réussi auprès de 15 familles volontaires d'un quartier donne une **piste**, pas une garantie. Après un transfert, on **évalue à nouveau**, avec les mêmes indicateurs si possible, pour vérifier que l'action garde son efficacité dans le nouveau contexte.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.20

Un projet « Fontaines à eau et défi zéro soda » (fictif) a réussi dans un collège urbain. Un collège rural, dont la moitié des élèves sont demi-pensionnaires et arrivent en car à 7 h 30, veut le reprendre. Identifiez deux

fonctions clés à conserver et deux éléments à adapter, avec une proposition d'adaptation pour chacun.

Corrigé

Fonctions clés : l'**accès gratuit à une eau fraîche** dans l'établissement ; l'**implication des élèves** dans le défi (élèves ambassadeurs). Éléments à adapter : les **horaires** (prévoir l'accès à l'eau dès l'arrivée des cars et pendant le temps de car, avec des gourdes) ; la **communication** (passer par les délégués de car et le foyer des internes ou demi-pensionnaires) ; on peut aussi adapter le nombre et l'emplacement des fontaines aux bâtiments.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 9.3.5 – Valoriser le projet

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel formulaire sert au compte rendu financier d'une subvention accordée à une association ?
2. Prévu 8 000 €, réalisé 7 200 € ; la subvention de 3 000 € est réduite au prorata si la réalisation est inférieure à 95 %. Calculez la subvention due.
3. Citez les six rubriques d'une note de synthèse pour des décideurs.
4. Donnez deux règles éthiques de la restitution aux participants.
5. Citez quatre conditions de pérennité d'une action.
6. Quelles sont les quatre dimensions de la grille ASTAIRE ?

Corrigé – Point d'étape 9.3.5

1. Le formulaire Cerfa n° 15059 « Compte rendu financier de subvention ».
2. Taux de réalisation : 7 200 / 8 000 = 90 %, inférieur à 95 % ; subvention due : 3 000 × 0,90 = 2 700 €.
3. Objet, contexte, résultats, coût, limites, proposition et décision demandée.
4. Résultats collectifs uniquement, pas de sous-groupe de moins de cinq personnes, langage positif sans jugement, droit à l'image respecté (deux au choix).
5. Portage, compétences, financement, intégration au projet de la structure, partenariats, outils, demande du public (quatre au choix).
6. Population, environnement, mise en œuvre, accompagnement du transfert.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 9.3.6.
3 ou 4 sur 6	Je relis le compte rendu financier et la pérennisation.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 9.3.5 et je refais les exercices d'application.

9.3.6 Rédiger les parties « évaluation » et « bilan » d'un dossier

Module · Référentiel : C3.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 9.2.2)

Méthode pas à pas – Plan conseillé

1. Plan d'évaluation : tableau des indicateurs (processus, résultats) avec valeur initiale, cible, outil, moment (½ page).

2. Résultats : processus (réalisations, participation, budget), puis résultats (par objectif spécifique), avec tableaux et graphiques interprétés selon la règle des 4 temps (1 à 2 pages).

3. Discussion : limites de l'évaluation, effets inattendus, difficultés rencontrées et ajustements réalisés (½

page).

4. Bilan et perspectives : ce que le projet a apporté au public et à la structure ; recommandations ; pérennisation ; transférabilité (½ page).

5. Auto-évaluation : compétences mobilisées, points forts, axes de progrès (fiche F14) (½ page).

Attention – Ce que le jury repère immédiatement

- Des résultats présentés **sans** comparaison à l'objectif ni à l'état initial.
- Des conclusions **trop affirmatives** (« le projet a fait baisser le surpoids »).
- L'absence de **limites** ou de **difficultés** (un projet sans difficulté n'est pas crédible).
- Des chiffres **incohérents** entre les parties (budget, présences, effectifs).
- Une valorisation réduite à « j'ai fait une affiche ».

Une partie « résultats » commentée : avant et après correction

Le meilleur moyen de comprendre ce que le jury attend est de comparer deux rédactions du même résultat. L'exemple porte sur un projet fictif mené dans un foyer de jeunes travailleurs : quatre ateliers « Cuisiner pour soi » pour 16 résidents, avec un objectif spécifique : « À la fin du projet, au moins 50 % des participants cuisinent un repas chaud au moins trois soirs par semaine. »

Erreurs fréquentes – Version à éviter

« Les ateliers se sont très bien passés et les jeunes ont beaucoup apprécié. Au début, peu de jeunes cuisinaient ; à la fin, la majorité cuisine. L'objectif est donc largement atteint. Le projet a permis d'améliorer l'alimentation des jeunes du foyer. Nous n'avons pas rencontré de difficulté particulière. »

Les défauts sont nombreux : aucune donnée chiffrée ni effectif ; « peu » et « la majorité » ne disent rien ; pas de comparaison chiffrée à la cible ; une conclusion sur « l'alimentation des jeunes du foyer » alors que seuls les participants ont été interrogés ; aucune limite ; « pas de difficulté » n'est pas crédible.

Exemple – Version attendue

« **Participation.** Les 4 ateliers prévus ont été réalisés ; 52 présences ont été enregistrées sur 64 possibles (16 inscrits × 4 ateliers), soit un taux de présence de **81,3 %**. **Résultat.** Parmi les 14 résidents qui ont répondu au questionnaire au premier et au dernier atelier, 4 cuisinaient un repas chaud au moins trois soirs par semaine au départ (28,6 %) et 9 à la fin (64,3 %), soit + 35,7 points. La cible de 50 % est dépassée (taux d'atteinte : 128,6 %). Le tableau de transition montre que 6 résidents ont adopté cette habitude et qu'un l'a abandonnée. **Interprétation.** Les résidents citent surtout les recettes à une seule casserole et la liste de courses type. **Limites.** Les données sont déclaratives, mesurées à la fin du cycle, sur 14 résidents volontaires ; deux résidents n'ont pas répondu à la fin ; le test de McNemar n'est pas applicable (7 changements seulement). **Difficultés et ajustements.** Le troisième atelier a été déplacé après une coupure de gaz ; l'horaire de 18 h a été avancé à 17 h 30 à la demande des résidents qui travaillent tôt. »

Calculs : 52 / 64 × 100 = 81,3 % ; 4 / 14 = 28,6 % ; 9 / 14 = 64,3 % ; 64,3 / 50 × 100 = 128,6 % ; changements b + c = 1 + 6 = 7, inférieur à 10. Le tableau de transition est cohérent : 3 résidents « oui » aux deux temps, 1 « oui » puis « non », 6 « non » puis « oui », 4 « non » aux deux temps (3 + 1 = 4 au départ ; 3 + 6 = 9 à la fin ; total 14).

Astuce – La structure d'un paragraphe de résultat

Pour chaque objectif : **ce qui a été mesuré** (outil, effectif) → **le résultat** avant et après, avec effectifs et pourcentages → **la comparaison à la cible** → **l'interprétation** (explications, verbatims) → **les limites**. Cette structure, répétée pour chaque objectif, rend le dossier facile à lire et à évaluer.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.21

Réécrivez la phrase suivante pour la rendre recevable dans un dossier : « Grâce au projet, les enfants du centre de loisirs boivent beaucoup plus d'eau. » Données : 30 enfants observés pendant trois goûters avant le projet, dont 11 ont bu de l'eau ; 30 enfants observés après, dont 19 ont bu de l'eau ; cible de 50 %.

Corrigé

« Lors de l'observation de trois goûters, 11 enfants sur 30 (36,7 %) ont bu de l'eau avant le projet, contre 19 sur 30 (63,3 %) après, soit + 26,7 points ; la cible de 50 % est dépassée (taux d'atteinte : 126,7 %). Il s'agit d'une observation sur quelques goûters, sans groupe de comparaison ; la saison (printemps puis début d'été) a pu jouer. » Calculs : 11 / 30 = 36,7 % ; 19 / 30 = 63,3 % ; 63,3 / 50 × 100 = 126,7 %.

Le vocabulaire de l'évaluation : écrire juste

Les mots choisis disent si l'on maîtrise l'évaluation. Un verbe trop fort transforme une évolution en preuve ; un mot vague rend un résultat inutilisable. Le tableau propose des formulations à préférer.

À éviter	À préférer	Pourquoi
« Le projet a prouvé que… »	« Les résultats suggèrent que… », « On observe que… »	Un avant / après sans comparaison ne prouve pas
« Grâce au projet, … »	« Pendant le projet, … » ou « Parmi les participants, … »	L'évolution peut avoir d'autres causes
« La majorité », « beaucoup », « peu »	« 9 participants sur 14 (64 %) »	Un résultat se chiffre, avec l'effectif
« Une augmentation de 20 % » (pour 30 % → 50 %)	« Une augmentation de 20 points » ou « de 67 % en valeur relative »	Points et pourcentage ne sont pas la même chose
« Les jeunes mangent mieux »	« La part des jeunes qui prennent un petit-déjeuner… »	Préciser l'indicateur
« L'objectif est raté »	« L'objectif est partiellement atteint (85 % de la cible) »	Juger avec des seuils, sans dramatiser
« Tous les participants sont satisfaits » (12 répondants sur 20)	« Les 12 répondants (sur 20 participants) se déclarent satisfaits »	Le dénominateur compte
« Le test montre que l'action est efficace »	« L'évolution est statistiquement significative »	Significatif ne veut pas dire « dû à l'action »

Définition – Points de pourcentage et variation relative

Quand un pourcentage passe de 30 % à 50 %, l'évolution est de **20 points de pourcentage** (50 − 30) ; la **variation relative** est de (50 − 30) / 30 × 100 = **66,7 %**. Les deux sont justes, mais ils ne disent pas la même chose. Dans un bilan, on donne de préférence l'évolution en points, et l'on précise « en valeur relative » si l'on donne la variation relative.

Exemple – Trois phrases réécrites

« Le projet a fait baisser le grignotage. » → « La part des salariés qui déclarent grignoter entre les repas est passée de 58 % à 41 % parmi les 36 répondants. » — « Les ateliers ont été un énorme succès. » → « Le taux de présence a été de 86 % et 22 participants sur 24 recommanderaient les ateliers. » — « Les résultats sont décevants. » → « L'objectif concernant les enfants n'est pas atteint (52 % pour une cible de 70 %) ; les entretiens montrent que les dégustations ont été trop peu nombreuses. »

Attention – Prudent ne veut pas dire flou

Une rédaction prudente reste **précise** et **assumée** : « La cible est dépassée » est une affirmation exacte ; ce qui doit être nuancé, c'est la **cause** de l'évolution et sa **généralisation**. Multiplier les « peut-être » et les « il semblerait » sur des résultats chiffrés affaiblit inutilement le dossier.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.22

La part des parents qui proposent de l'eau au goûter passe de 25 % à 45 %. a) Calculez l'évolution en points et la variation relative. b) Corrigez la phrase : « Grâce aux ateliers, la consommation d'eau a augmenté de 20 %. »

Corrigé

a) Évolution : 45 − 25 = **+ 20 points** ; variation relative : (45 − 25) / 25 × 100 = **+ 80 %**. b) « Pendant le cycle d'ateliers, la part des parents qui déclarent proposer de l'eau au goûter est passée de 25 % à 45 % (+ 20 points), parmi les [effectif] parents qui ont répondu aux deux questionnaires. » On remplace « grâce aux ateliers » par une formulation neutre, on parle de la part des parents (l'indicateur mesuré) et l'on écrit « 20 points ».

L'analyse critique de sa démarche

La dernière partie du dossier porte sur la démarche elle-même : qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a posé problème, qu'aurait-on fait autrement ? Cette **analyse critique** n'est pas un aveu d'échec : elle montre au jury la capacité à prendre du recul, une compétence attendue du diététicien.

Étape du projet	Questions d'analyse critique
Diagnostic	Les données étaient-elles suffisantes ? Le public a-t-il été associé ?
Objectifs	Étaient-ils réalistes et mesurables ? Les cibles étaient-elles justifiées ?
Actions	Les méthodes étaient-elles adaptées au public ? Les stratégies étaient-elles combinées ?
Organisation	Le calendrier et le budget ont-ils été tenus ? Quels imprévus, quels ajustements ?
Partenariat	Les rôles étaient-ils clairs ? Les partenaires se sont-ils impliqués ?
Évaluation	Les outils ont-ils mesuré ce qu'il fallait ? Quels biais ? Que manquait-il ?
Posture	Comment ai-je communiqué, animé, pris des décisions ? Qu'ai-je appris ?

Méthode pas à pas – Rédiger l'analyse critique en quatre paragraphes

1. Les points forts : deux ou trois réussites, appuyées sur des faits (« le taux de présence de 81 % montre que l'horaire choisi avec les résidents convenait »).

2. Les difficultés : deux ou trois difficultés réelles, avec leur cause (« le recrutement a été lent, car l'information passait uniquement par affichage »).

3. Les ajustements réalisés : ce que vous avez modifié en cours de route, et l'effet de ces ajustements.

4. Ce que vous feriez autrement : des propositions précises pour un prochain projet, y compris sur l'évaluation.

Exemple – Un extrait d'analyse critique

« Le diagnostic participatif a été un point fort : les recettes choisies par les résidents ont été refaites à la maison par 9 participants sur 14. En revanche, mon questionnaire initial comportait 22 questions ; plusieurs résidents l'ont trouvé trop long et deux ne l'ont pas terminé. Je l'ai réduit à 8 questions pour le questionnaire final, ce qui m'a obligée à ne comparer que les 8 questions communes. Pour un prochain projet, je prétesterais le questionnaire auprès de trois personnes du public et je prévoirais dès le départ une observation des repas, pour ne pas dépendre uniquement des déclarations. » (exemple fictif)

Attention – Ni autosatisfaction, ni autoflagellation

Un dossier qui ne présente que des réussites n'est pas crédible ; un dossier qui accumule les regrets sans analyse ne l'est pas davantage. L'équilibre attendu : des points forts et des difficultés appuyés sur des faits, et des propositions concrètes.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.23

Une stagiaire écrit : « Mon projet a été une réussite totale, je n'ai rencontré aucune difficulté et je ne changerais rien. » Ses données montrent pourtant un taux de présence de 58 % et seulement 9 questionnaires finaux sur 20 participants. Rédigez deux phrases d'analyse critique plus justes.

Corrigé

Exemple : « La participation a été plus faible que prévu (58 % de présence pour une cible de 75 %), en partie parce que les ateliers avaient lieu en fin d'après-midi, au moment de la sortie de l'école. Seuls 9 participants sur 20 ont rempli le questionnaire final, ce qui limite la portée des résultats ; je prévoirais aujourd'hui un temps dédié au questionnaire pendant le dernier atelier et une relance par téléphone. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 9.3.6 – Rédiger l'évaluation et le bilan

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez les cinq éléments d'un paragraphe de résultat bien construit.
2. Un pourcentage passe de 40 % à 60 %. Donnez l'évolution en points et la variation relative.
3. Réécrivez de façon prudente : « Le projet a prouvé que les ateliers font manger plus de légumes. »
4. Pourquoi faut-il présenter des difficultés dans un dossier ?
5. Citez les quatre paragraphes d'une analyse critique.
6. 52 présences pour 16 inscrits et 4 ateliers : calculez le taux de présence.

Corrigé – Point d'étape 9.3.6

1. Ce qui a été mesuré (outil, effectif), le résultat avant et après, la comparaison à la cible, l'interprétation, les limites.
2. + 20 points ; variation relative : 20 / 40 × 100 = + 50 %.
3. « Parmi les participants interrogés, la part qui mange des légumes chaque jour est passée de … à … ; sans groupe de comparaison, cette évolution ne peut pas être attribuée avec certitude aux ateliers. »
4. Parce qu'un projet sans difficulté n'est pas crédible et que l'analyse des difficultés montre la capacité de recul et d'ajustement.
5. Points forts, difficultés, ajustements réalisés, ce que l'on ferait autrement.
6. 52 / (16 × 4) × 100 = 52 / 64 × 100 = 81,3 %.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 9.3.7.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau du vocabulaire et l'exemple commenté.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 9.3.6 et je refais les exercices d'application.

9.3.7 Analyser des données avant/après appariées

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 9.2.2)

Quand les **mêmes personnes** répondent avant et après (code anonyme, fiche F11), on peut analyser l'évolution **individuelle**, plus riche que la seule comparaison des moyennes.

Variable binaire : le tableau de transition

Exemple – Calcul détaillé : consommation de légumes secs avant et après (12 familles)

Avant ↓ / Après →	≥ 2 fois par semaine	Moins souvent	Total avant
≥ 2 fois par semaine	3	0	3
Moins souvent	6	3	9
Total après	9	3	12

- **Stables positives** (déjà ≥ 2 fois, toujours) : 3 ; **progression** (passées à ≥ 2 fois) : **6** ; **régression** : 0 ; **stables négatives** : 3.
- Avant : 3 / 12 = **25 %** ; après : 9 / 12 = **75 %**.
- Parmi les familles qui pouvaient progresser (9) : 6 / 9 × 100 = **66,7 %** ont progressé ; c'est un indicateur plus parlant que la seule différence de pourcentages.
- Le **test de McNemar** (9.5) utilise justement les cases de changement (6 et 0).

Variable quantitative : progression individuelle

Exemple – Calcul détaillé : répartition des progressions de score

À partir des scores avant et après des 12 participants (chapitre 1, fiche F11), les différences individuelles (après − avant) sont : 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2.

- Progression de **3 points** : 5 participants ; de **2 points** : 7 participants ; aucune progression nulle ou négative.
- Part ayant progressé : 12 / 12 = **100 %** ; progression moyenne : (5 × 3 + 7 × 2) / 12 = (15 + 14) / 12 = 29 / 12 = **2,42 points**.
- Participants sous 5/10 avant (scores 3, 3, 4, 4, 4 : 5 personnes) : leurs scores après sont 6, 6, 7, 6, 7 ; progression moyenne : (3 + 3 + 3 + 2 + 3) / 5 = 14 / 5 = **2,8 points**, contre (2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2) / 7 = 15 / 7 = **2,14 points** pour les autres.

Lecture : les participants qui partaient de plus loin ont progressé davantage : l'action a **réduit les écarts** de connaissances au sein du groupe (effet favorable à l'équité ; attention toutefois à l'effet de « régression vers la moyenne », 9.5).

Attention – Ne comparer que ce qui est comparable

Si 15 personnes répondent avant et 10 après, comparer 15 réponses « avant » à 10 réponses « après » mélange deux groupes différents (les absents sont peut-être les moins convaincus). On analyse en priorité les **réponses appariées** (les 10 personnes présentes aux deux temps) et l'on indique le nombre de **perdus de vue**.

Le tableau de transition à plusieurs niveaux

Le tableau de transition (9.3.7) ne se limite pas aux réponses oui / non. Quand la réponse comporte plusieurs niveaux ordonnés (jamais, parfois, souvent), on construit un tableau à trois lignes et trois colonnes. Les cases de la **diagonale** correspondent aux personnes **stables** ; les cases **au-dessus** de la diagonale (vers la droite) aux personnes qui ont **progressé** d'au moins un niveau ; les cases **en dessous** à celles qui ont **régressé**.

Exemple – Calcul détaillé : fréquence de consommation de légumes secs chez 20 participants

Question posée avant et après un cycle d'ateliers (données fictives) : « Combien de fois par semaine mangez-vous des légumes secs ? »

Avant ↓ / Après →	Jamais	1 fois	2 fois ou plus	Total avant
Jamais	2	4	2	8
1 fois	1	3	4	8
2 fois ou plus	0	1	3	4
Total après	3	8	9	20

- **Stables** (diagonale) : 2 + 3 + 3 = **8**.
- **Progression** d'au moins un niveau : 4 + 2 + 4 = **10** (dont 2 qui passent directement de « jamais » à « 2 fois ou plus »).
- **Régression** : 1 + 0 + 1 = **2**.
- Contrôle : 8 + 10 + 2 = 20.
- Part des participants qui mangent des légumes secs au moins 2 fois par semaine : 4 / 20 = **20 %** avant, 9 / 20 = **45 %** après (+ 25 points).
- Part ayant progressé parmi ceux qui pouvaient progresser (16 personnes qui n'étaient pas au niveau le plus élevé) : 10 / 16 = **62,5 %**.
- Personnes qui ne mangent jamais de légumes secs : 8 / 20 = **40 %** → 3 / 20 = **15 %**.

Astuce – Regarder les extrêmes

Dans un tableau à plusieurs niveaux, les cases d'angle sont souvent les plus intéressantes : les personnes qui partaient de « jamais » et qui atteignent le niveau le plus élevé montrent un changement fort ; celles qui partaient de « jamais » et y restent (ici 2) sont peut-être celles que l'action n'a pas su toucher. Un entretien avec elles peut révéler des freins (goût, temps de cuisson, coût, habitudes familiales).

Attention – Regrouper pour le test, pas pour la description

Le test de McNemar s'applique à un tableau oui / non. Pour l'utiliser, on regroupe les niveaux (par exemple « 2 fois ou plus » contre « moins de 2 fois »). Mais la description complète du tableau à trois niveaux reste plus riche : elle montre des progressions (de « jamais » à « 1 fois ») qui disparaissent dans le regroupement.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.24

À partir du tableau de l'exemple, regroupez les réponses en « 2 fois ou plus » et « moins de 2 fois ». a) Construisez le tableau oui / non. b) Calculez b, c et le test de McNemar. c) Quelle information le regroupement fait-il perdre ?

Corrigé

a) « Oui » avant et après : 3 ; « oui » avant, « non » après : 1 ; « non » avant, « oui » après : 2 + 4 = 6 ; « non » aux deux temps : 2 + 4 + 1 + 3 = 10 (total 20). b) b = 1, c = 6 ; b + c = 7, inférieur à 10 : test peu fiable ; à titre indicatif $\chi^2 = (|1 - 6| - 1)^2 / 7 = 16 / 7 = 2{,}29$, inférieur à 3,84. c) Le regroupement fait disparaître les **4 personnes passées de « jamais » à « 1 fois »**, un vrai progrès pour des personnes qui ne mangeaient jamais de légumes secs.

Les perdus de vue : analyser sans tricher

Dans presque tous les projets, certaines personnes répondent au premier questionnaire mais pas au dernier : elles ont abandonné, étaient absentes, ou ont refusé. Ces **perdus de vue** posent un problème, car ils ne sont pas tirés au hasard : ce sont souvent les personnes les moins satisfaites ou celles qui ont le moins changé.

Méthode d'analyse	Principe	Risque
Cas complets	On n'analyse que les personnes qui ont répondu aux deux temps	Résultat trop optimiste si les perdus de vue ont moins changé
Report de la valeur initiale	On considère que les perdus de vue n'ont pas changé	Hypothèse prudente, souvent réaliste
Hypothèse pessimiste	Tous les perdus de vue sont comptés comme « non » à la fin	Sous-estime le résultat
Hypothèse optimiste	Tous les perdus de vue sont comptés comme « oui » à la fin	Surestime le résultat

Exemple – Calcul détaillé : quatre façons de présenter le même résultat

Un cycle d'ateliers (fictif) compte 24 inscrits. Au premier atelier, 8 sur 24 déclarent prendre un petit-déjeuner chaque jour. Au dernier atelier, 18 participants répondent ; parmi eux, 6 avaient répondu « oui » au départ et 12 répondent « oui » à la fin. Les 6 perdus de vue comptaient donc 8 − 6 = 2 « oui » au départ.

- **Cas complets** : 6 / 18 = **33,3 %** → 12 / 18 = **66,7 %**.
- **Report de la valeur initiale** : 12 + 2 = 14 « oui » sur 24, soit **58,3 %**.
- **Hypothèse pessimiste** : 12 / 24 = **50,0 %**.
- **Hypothèse optimiste** : (12 + 6) / 24 = 18 / 24 = **75,0 %**.
- Au départ, la part de « oui » était la même chez les 24 inscrits (8 / 24 = 33,3 %) et chez les 18 répondants (6 / 18 = 33,3 %) : les répondants ne semblaient pas différents au départ, ce qui rassure un peu.

Présentation conseillée : « Parmi les 18 participants qui ont répondu aux deux questionnaires, la part qui prend un petit-déjeuner chaque jour est passée de 33,3 % à 66,7 %. Rapporté aux 24 inscrits, le résultat final se situe entre 50,0 % et 75,0 % selon les hypothèses faites sur les 6 perdus de vue. »

Méthode pas à pas – Réduire et décrire les perdus de vue

1. Prévenir : questionnaire final pendant un atelier (pas à la maison), relance des absents, accord pour être recontacté.

2. Compter : nombre de perdus de vue et raisons connues (déménagement, horaires, désintérêt).

3. Comparer leur profil de départ à celui des répondants (réponses initiales, âge, ancienneté).

4. Présenter le résultat sur les cas complets, puis l'encadrer par les hypothèses pessimiste et optimiste.

5. Discuter le sens probable du biais dans les limites.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.25

30 personnes ont rempli le questionnaire initial, dont 9 consommaient un fruit chaque jour. 22 ont rempli le

questionnaire final : 7 d'entre elles consommaient un fruit chaque jour au départ, 15 à la fin. Calculez le résultat final sur les cas complets, avec report de la valeur initiale, et selon les hypothèses pessimiste et optimiste.

Corrigé

Cas complets : 15 / 22 = **68,2 %** (contre 7 / 22 = 31,8 % au départ). Les 8 perdus de vue comptaient 9 − 7 = 2 « oui » au départ. Report de la valeur initiale : (15 + 2) / 30 = 17 / 30 = **56,7 %**. Pessimiste : 15 / 30 = **50,0 %**. Optimiste : (15 + 8) / 30 = 23 / 30 = **76,7 %**. Le résultat réel se situe probablement entre 50 % et 77 % ; on présente 68,2 % en précisant qu'il porte sur 22 personnes sur 30.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 9.3.7 – Analyser des données appariées

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que représentent les cases de la diagonale d'un tableau de transition ?
2. Dans un tableau à trois niveaux, où se trouvent les personnes qui ont progressé ?
3. Pourquoi faut-il analyser en priorité les réponses appariées ?
4. 20 inscrits, 15 répondants à la fin dont 9 « oui ». Donnez le résultat sur les cas complets et selon l'hypothèse pessimiste.
5. Pourquoi les perdus de vue ne sont-ils pas « tirés au hasard » ?
6. Quelle information un regroupement en oui / non peut-il faire perdre ?

Corrigé – Point d'étape 9.3.7

1. Les personnes stables, qui ont donné la même réponse avant et après.
2. Au-dessus de la diagonale (vers la droite), quand les niveaux sont rangés dans le même ordre en ligne et en colonne.
3. Pour comparer les mêmes personnes et ne pas confondre une évolution avec un changement dans la composition du groupe.
4. Cas complets : 9 / 15 = 60,0 % ; pessimiste : 9 / 20 = 45,0 %.
5. Parce que ce sont souvent les personnes les moins satisfaites, les moins disponibles ou celles qui ont le moins changé.
6. Les progressions entre niveaux intermédiaires (par exemple de « jamais » à « une fois par semaine »).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 9.3.8.
3 ou 4 sur 6	Je refais les calculs du tableau à trois niveaux et des perdus de vue.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 9.3.7 et je refais les exercices d'application.

9.3.8 L'évaluation qualitative

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 9.2.2)

Les chiffres disent **combien** ; les données qualitatives disent **comment** et **pourquoi**. Elles éclairent les mécanismes, les effets inattendus, la qualité perçue, et donnent la parole aux participants.

Méthode	Usage en évaluation
Entretien individuel de bilan	Comprendre ce qui a changé pour une personne, les freins persistants (5 à 8 entretiens suffisent souvent à repérer les thèmes principaux)
Groupe de parole d'évaluation	Bilan collectif : « Qu'est-ce qui vous a été utile ? Qu'est-ce qui a changé chez vous ? Qu'est-ce qu'on devrait changer ? »
Technique du « changement le plus significatif »	Chaque participant raconte le changement le plus important qu'il a vécu grâce au projet ; le groupe sélectionne et discute les récits (Davies et Dart, 2005)
Carnet de bord des animateurs	Observations, incidents, ajustements, citations
Photo-expression de bilan	« Choisissez une photo qui représente ce que vous retenez du cycle »

Méthode pas à pas – Analyser des réponses ouvertes en 5 étapes

1. Rassembler toutes les réponses (verbatims) en respectant l'anonymat.

2. Lire l'ensemble une première fois.

3. Coder : attribuer à chaque réponse un ou plusieurs thèmes (« économie », « plaisir de cuisiner », « enfants », « convivialité », « temps »).

4. Compter les thèmes (nombre de personnes qui les évoquent) et sélectionner des citations représentatives.

5. Interpréter en lien avec les objectifs et les résultats chiffrés (convergences, contradictions).

Exemple – Calcul détaillé : codage des réponses à « Qu'allez-vous refaire à la maison ? » (12 participants)

Thème	Participants (n = 12)	Exemple de verbatim
Recette de légumes secs	9 (75 %)	« Le parmentier de lentilles, mes enfants l'ont redemandé. »
Goûters maison	6 (50 %)	« Le crumble pour le goûter, c'est moins cher que les biscuits. »
Calculer le prix par portion	4 (33 %)	« Je regarde maintenant le prix au kilo. »
Cuisiner avec les enfants	4 (33 %)	« Ma fille épluche les carottes avec moi. »
Rien de nouveau	1 (8 %)	« Je cuisinais déjà comme ça. »

- Calcul des pourcentages : 9 / 12 = 75 % ; 6 / 12 = 50 % ; 4 / 12 = 33 % ; 1 / 12 = 8 % ; le total dépasse 100 % car une réponse peut contenir plusieurs thèmes.
- **Convergence** : les 75 % qui citent une recette de légumes secs rejoignent l'indicateur quantitatif (75 % de consommateurs après le cycle).

Conduire un entretien d'évaluation

L'entretien individuel **semi-directif** est l'outil qualitatif le plus utilisé pour comprendre ce qui a changé pour une personne et pourquoi. Il suit un **guide d'entretien** (quelques thèmes et questions ouvertes) mais laisse la personne s'exprimer librement.

Méthode pas à pas – Préparer et conduire l'entretien

1. Choisir les personnes : diversifier les profils (participants assidus et irréguliers, satisfaits et critiques, personnes qui ont abandonné). Cinq à huit entretiens suffisent souvent pour faire apparaître les thèmes principaux d'un petit projet.

2. Rédiger le guide : quatre à six questions ouvertes, du général au particulier (« Comment s'est passé le cycle pour vous ? » puis « Qu'avez-vous refait à la maison ? » puis « Qu'est-ce qui vous a gêné ? »).

3. Présenter l'entretien : objectif, durée (20 à 30 minutes), confidentialité, droit de ne pas répondre, accord pour prendre des notes ou enregistrer.

4. Écouter plus que parler : laisser des silences, ne pas donner son avis, ne pas corriger les connaissances pendant l'entretien.

5. Relancer : écho (répéter le dernier mot), reformulation (« Si je comprends bien, vous… »), demande d'exemple (« Pouvez-vous me raconter une fois où… ? »).

6. Conclure : « Y a-t-il quelque chose que vous voudriez ajouter ? », remercier, expliquer ce que deviendront les réponses.

7. Noter immédiatement après l'entretien : les idées principales, quelques verbatims exacts, le contexte.

Technique de relance	Exemple	Effet
Écho	« Trop cher ? »	Invite à développer sans orienter
Reformulation	« Vous voulez dire que l'horaire tombait mal avec la sortie de l'école ? »	Vérifie la compréhension, montre l'écoute
Demande d'exemple	« Pouvez-vous me raconter la dernière fois que vous avez cuisiné des lentilles ? »	Passe de l'opinion au fait vécu
Silence	Attendre quelques secondes	Laisse le temps de réfléchir
Question de contraste	« Et qu'est-ce qui a été le moins utile ? »	Fait émerger les critiques

Attention – L'animateur n'est pas le meilleur interviewer

Les participants hésitent à critiquer la personne qui a animé les ateliers. Si possible, les entretiens sont menés par une autre personne (une collègue, la tutrice, un partenaire). Sinon, on le signale dans les limites et l'on insiste au début sur l'intérêt des critiques pour améliorer l'action.

Exemple – Une relance qui change tout

Question : « Avez-vous refait des recettes ? » Réponse : « Oui, oui, un peu. » Relance par demande d'exemple : « Laquelle, et comment cela s'est-il passé ? » Réponse : « En fait, j'ai essayé le curry de pois chiches une fois, mais mon mari n'aime pas, alors j'ai arrêté. Je fais toujours les mêmes plats. » La relance transforme un « oui » de politesse en information utile : le frein est l'acceptation par la famille, ce qui conduit à proposer des recettes à tester avec les proches et un atelier ouvert aux familles.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.26

Pendant un entretien de bilan avec un résident d'une résidence autonomie (fictive), il dit : « Les ateliers, c'était bien, mais bon… » Proposez trois relances différentes et indiquez ce que chacune peut apporter.

Corrigé

Écho : « Mais bon… ? » : invite à poursuivre sans orienter. Reformulation : « Vous avez l'air d'avoir une réserve, est-ce que je me trompe ? » : montre l'écoute et autorise la critique. Demande d'exemple : « Y a-t-il un moment des ateliers qui vous a moins plu ? » : fait passer à un fait précis. On peut aussi laisser un silence. Chacune peut faire apparaître une critique (horaire, contenu, ambiance, difficulté physique) utile pour ajuster l'action.

Animer un entretien collectif de bilan

L'**entretien collectif** (ou groupe focalisé, *focus group*) réunit six à dix personnes pendant une heure environ autour de quelques questions ouvertes. Les participants réagissent aux propos des autres, ce qui fait émerger des idées qu'un entretien individuel ne révèle pas toujours : expériences partagées, désaccords, propositions.

Élément	Recommandation
Composition	6 à 10 personnes ; groupe assez homogène pour que chacun ose parler (par exemple, pas de responsable hiérarchique dans un groupe de salariés)
Durée	45 à 90 minutes
Rôles	Un animateur qui pose les questions et distribue la parole ; un observateur qui note les propos, les réactions et les silences
Guide	4 à 6 questions ouvertes, de la plus générale à la plus précise, et une question finale de propositions
Lieu	Calme, familier pour les participants, disposition en cercle
Traces	Notes de l'observateur ; enregistrement seulement avec l'accord de tous

Méthode pas à pas – Déroulé type d'un entretien collectif d'évaluation

1. Accueil (5 min) : présentation des personnes, de l'objectif, des règles (une personne parle à la fois, pas de bonne ou mauvaise réponse, confidentialité de ce qui est dit).

2. Question d'ouverture (10 min) : « En un mot, que retenez-vous de ces ateliers ? » (tour de table : tout le monde parle une première fois).

3. Questions centrales (30 min) : « Qu'est-ce qui a changé pour vous ? », « Qu'est-ce qui vous a aidé ? », « Qu'est-ce qui a été difficile ou gênant ? ».

4. Propositions (10 min) : « Si l'on refaisait le cycle, que faudrait-il changer ? »

5. Synthèse et clôture (5 min) : l'animateur résume les idées principales et demande si elles reflètent bien ce qui a été dit.

Attention – Gérer les dynamiques de groupe

Un participant qui monopolise la parole, un autre qui ne dit rien, un consensus de façade : ces situations faussent les résultats. L'animateur utilise le tour de table, sollicite les silencieux avec bienveillance (« Et vous, comment cela s'est-il passé ? »), et accueille explicitement les avis divergents (« Quelqu'un a-t-il vécu les choses autrement ? »).

Exemple – Ce que l'entretien collectif a révélé

Dans un projet d'ateliers pour des aidants familiaux (fictif), les questionnaires indiquaient une satisfaction de 95 %. L'entretien collectif a fait apparaître un point que personne n'avait écrit : plusieurs aidants n'avaient pu venir qu'en confiant leur proche à un voisin, et s'étaient sentis coupables. Le groupe a proposé un accueil de jour en parallèle des ateliers. Ce besoin, partagé par cinq personnes sur huit, n'aurait pas été repéré par le questionnaire.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.27

Vous organisez un entretien collectif de bilan avec les salariés d'un atelier de production (fictif) après un projet sur l'alimentation pendant le travail posté. La directrice propose d'y assister « pour entendre les retours ». Que lui répondez-vous ? Proposez une alternative.

Corrigé

Sa présence risquerait de **freiner la parole** des salariés (lien hiérarchique, peur du jugement), et les critiques sur l'organisation du travail, souvent centrales dans ce type de projet, ne seraient pas exprimées. Alternative : mener l'entretien sans elle, avec un observateur extérieur, puis lui restituer une **synthèse anonyme** des idées et des propositions, présentée lors d'une réunion dédiée.

Trianguler : croiser les sources pour conclure

Trianguler, c'est croiser au moins deux sources, deux méthodes ou deux points de vue sur la même question. Si elles convergent, la conclusion est renforcée ; si elles divergent, la divergence elle-même est une information à analyser.

Type de triangulation	Exemple
Des méthodes	Questionnaire (déclaré) et pesée des restes (observé)
Des sources	Participants, animateurs, partenaires, familles
Des moments	Fin du cycle et trois mois après
Des évaluateurs	Stagiaire et tutrice qui observent la même séance

Exemple – Calcul détaillé : un tableau de triangulation

Projet fictif dans un restaurant d'entreprise : un « plat végétarien du jour » est proposé pendant trois mois.

Question	Questionnaire (98 répondants)	Données de caisse	Entretiens (8 salariés)	Conclusion
Le plat végétarien est-il choisi plus souvent ?	41 % disent le choisir au moins une fois par semaine	14 % des plats vendus le premier mois, 22 % le troisième	« J'ai découvert des plats que je ne connaissais pas »	**Convergence** : progression nette
Le plat est-il apprécié ?	76 % satisfaits	Restes : 38 g par assiette, contre 31 g pour le plat avec viande	« Les portions sont parfois trop petites, alors je prends un dessert en plus »	**Divergence partielle** : apprécié, mais portion et satiété à revoir
Le prix est-il un frein ?	12 % citent le prix	Prix identique au plat avec viande	Aucun salarié n'évoque le prix	**Convergence** : le prix n'est pas un frein

Évolution de la part du plat végétarien dans les ventes : 22 − 14 = **+ 8 points**, soit (22 − 14) / 14 × 100 = **+ 57 %** en valeur relative. Différence de restes : 38 − 31 = **7 g** de plus par assiette pour le plat végétarien.

Lecture : les trois sources confirment l'adoption du plat ; elles divergent sur l'appréciation, et les entretiens expliquent la divergence (portions et satiété). Recommandation : enrichir les plats en légumineuses et en féculents, et vérifier les grammages.

Astuce – Une divergence n'est pas un échec de l'évaluation

Quand les déclarations et les observations ne disent pas la même chose, c'est souvent là que l'évaluation devient la plus utile : elle révèle un biais de désirabilité, un problème pratique ou un effet inattendu. Présentez la divergence, proposez une explication, et indiquez comment la vérifier.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.28

Dans un projet sur les goûters (fictif), 85 % des parents déclarent donner un fruit au goûter, mais l'observation des goûters apportés montre un fruit dans 40 % des sacs. Proposez trois explications et une

façon de les vérifier.

Corrigé

Explications : la **désirabilité sociale** (les parents répondent ce qu'ils pensent attendu) ; une différence de **période** (le fruit est donné à la maison, pas dans le sac du centre de loisirs) ; des parents répondants **différents** des parents dont on a observé les sacs (tous n'ont pas répondu). Vérification : un entretien collectif avec quelques parents (« Comment se passe le goûter chez vous et au centre ? ») et une comparaison limitée aux familles qui ont répondu et dont l'enfant a été observé.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 9.3.8 – L'évaluation qualitative

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. À quelles questions l'évaluation qualitative répond-elle surtout ?
2. Citez trois techniques de relance en entretien.
3. Combien de personnes réunit-on pour un entretien collectif, et pendant combien de temps ?
4. Quels sont les rôles de l'animateur et de l'observateur ?
5. Qu'est-ce que trianguler ? Donnez un exemple.
6. Pourquoi l'animateur du projet n'est-il pas la personne la mieux placée pour mener les entretiens de bilan ?

Corrigé – Point d'étape 9.3.8

1. Pourquoi et comment : mécanismes, freins, leviers, effets inattendus, vécu des participants.
2. Écho, reformulation, demande d'exemple, silence, question de contraste (trois au choix).
3. 6 à 10 personnes, pendant 45 à 90 minutes.
4. L'animateur pose les questions et distribue la parole ; l'observateur note les propos, les réactions et les silences.
5. Croiser au moins deux sources ou méthodes sur une même question, par exemple un questionnaire et une pesée des restes.
6. Parce que les participants hésitent à le critiquer (désirabilité sociale) et qu'il peut orienter, sans le vouloir, les réponses ou leur interprétation.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 9.3.9.
3 ou 4 sur 6	Je relis les méthodes d'entretien et la triangulation.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 9.3.8 et je refais les exercices d'application.

9.3.9 Évaluer l'animation : observer et s'auto-évaluer

Module · Référentiel : C3.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 9.2.2)

L'évaluation porte aussi sur la **qualité de l'intervention** : déroulement, posture, méthodes. Elle permet d'ajuster les séances suivantes (évaluation formative) et nourrit l'**auto-évaluation** demandée par le référentiel (fiche F14).

Respect du conducteur (étapes, horaires)

Clarté des consignes et des messages (langage, supports)

Participation de tous (temps de parole, activités)

Climat (bienveillance, absence de jugement, sécurité)

Adaptation aux imprévus (retards, refus, incident)

Respect de l'hygiène et de la sécurité

Vérification de la compréhension (faire dire)

Atteinte de l'objectif de la séance

Exemple – Calcul détaillé : synthèse de l'observation de trois séances

La tutrice a observé les ateliers 1, 2 et 3 avec la grille (8 critères notés de 1 à 4, maximum 32 points). Totaux : atelier 1 : **22** ; atelier 2 : **25** ; atelier 3 : **29**.

- En pourcentage du maximum : 22 / 32 = **68,8 %** ; 25 / 32 = **78,1 %** ; 29 / 32 = **90,6 %**.
- Progression : 29 − 22 = **+ 7 points** (+ 21,9 points de pourcentage).
- Critère le plus faible à l'atelier 1 : « participation de tous » (note 2 : une participante monopolisait la parole) ; à l'atelier 3 : 4, grâce au tour de parole et aux rôles en binôme (chapitre 3).

Usage dans le dossier : ces données objectivent l'auto-évaluation (« j'ai amélioré la gestion du temps de parole ») et montrent la capacité d'**ajustement**, un indicateur du référentiel.

Évaluer un support d'information ou un outil pédagogique

Un livret de recettes, une affiche, une vidéo ou un jeu sont des **réalisations** du projet. Leur qualité conditionne les résultats : un livret que personne ne comprend ne changera aucune pratique. On évalue un support **avant** sa diffusion (prétest) et **après** (usage réel).

Critère	Questions	Méthode
Compréhension	Le public comprend-il le message principal ?	Faire reformuler le message par 5 à 8 personnes du public
Lisibilité	Phrases courtes, mots courants, police lisible, contraste suffisant ?	Grille de lisibilité, relecture par une personne extérieure
Attractivité	Le support donne-t-il envie d'être lu ou utilisé ?	Avis du public, observation (qui le prend, qui le garde)
Acceptabilité	Le message est-il respectueux, non culpabilisant, adapté à la culture du public ?	Discussion avec des personnes du public et des relais
Exactitude	Les informations sont-elles justes, sourcées et datées ?	Vérification par un professionnel
Utilisation	Le support est-il réellement utilisé ?	Nombre d'exemplaires pris, recettes refaites, consultations du lien

Méthode pas à pas – Prétester un support en cinq étapes

1. Préparer une version provisoire, sans impression définitive.

2. Choisir cinq à huit personnes du public visé, de profils variés (âge, langue, niveau de lecture).

3. Les laisser découvrir seules le support pendant quelques minutes, sans explication.

4. Poser trois questions : « Qu'avez-vous compris ? », « Qu'est-ce qui vous a plu ou gêné ? », « Qu'allez-vous en faire ? ».

5. Modifier le support en fonction des réponses, puis vérifier la nouvelle version auprès de deux ou trois personnes.

Exemple – Le prétest d'une affiche sur l'hydratation

Une affiche (fictive) destinée aux résidents d'un EHPAD porte le titre « Hydratez-vous ! 1,5 L/j » et une illustration de bouteille. Au prétest auprès de six résidents, quatre ne comprennent pas « 1,5 L/j », deux

pensent qu'il faut acheter des bouteilles, et trois disent ne pas aimer l'eau plate. L'affiche est modifiée : titre « Un verre à chaque occasion », illustrations de boissons variées (eau, tisane, soupe, lait, jus de fruits dilué), et pictogrammes des moments de la journée. Lors du second prétest, cinq résidents sur six reformulent correctement le message.

Attention – Un support n'est pas une action

Distribuer un livret n'est pas éduquer. L'évaluation d'un support porte sur sa qualité et son usage ; l'évaluation du projet porte sur les changements chez le public. Le jury repère vite un dossier dont le seul « résultat » est « 150 livrets distribués » : c'est une réalisation, pas un résultat.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.29

Un livret de recettes « petit budget » (fictif) a été distribué à 200 exemplaires lors d'une fête de quartier. Proposez deux indicateurs de réalisation, deux indicateurs d'utilisation et une méthode pour savoir si les recettes ont été refaites.

Corrigé

Réalisation : nombre d'exemplaires imprimés et distribués ; nombre de lieux de diffusion. Utilisation : nombre d'exemplaires pris dans les présentoirs après la fête (réassort) ; nombre de connexions à la version en ligne (code imprimé sur le livret). Recettes refaites : un court questionnaire ou un appel à un échantillon de personnes qui ont accepté d'être recontactées (« Avez-vous refait une recette du livret ? Laquelle ? »), ou un concours photo de recettes refaites.

L'évaluation formative pendant la séance

L'évaluation n'attend pas la fin du projet. Pendant chaque séance, des techniques rapides permettent de vérifier la compréhension et d'**ajuster** immédiatement : c'est l'**évaluation formative**. Elle prend quelques minutes et donne des informations précieuses pour la séance suivante.

Technique	Déroulé	Ce qu'elle apporte
Faire dire	« Qui peut expliquer avec ses mots comment on repère les sucres sur l'étiquette ? »	Vérifie la compréhension réelle
Cartons de couleur	Chacun lève un carton vert (j'ai compris), orange (pas sûr), rouge (pas compris)	Vue d'ensemble immédiate, anonymat relatif
Ticket de sortie	Sur un papier : « une chose que je retiens, une question qui me reste »	Traces écrites, questions à reprendre
Mini-quiz par vote	Trois questions, réponses à main levée ou avec des cartes A, B, C	Repère les notions mal comprises
Météo de fin de séance	Soleil, nuage, pluie pour dire comment on se sent	Climat du groupe, enfants
Démonstration	Le participant réalise le geste (lire une étiquette, composer un plateau)	Mesure une compétence

Exemple – Calcul détaillé : exploiter des tickets de sortie

À la fin du troisième atelier d'un cycle (fictif), 14 participants remplissent un ticket de sortie. 11 citent correctement au moins deux repères sur la lecture des étiquettes (**11 / 14 = 78,6 %**) ; 3 citent un repère inexact (par exemple « les produits allégés sont toujours meilleurs »). Les questions restantes portent surtout sur les sucres « cachés » (6 tickets sur 14, **42,9 %**). Aux cartons de couleur, la stagiaire avait compté 9 verts, 4

orange et 1 rouge (**9 / 14 = 64,3 %** de verts). La séance suivante commence par un rappel de cinq minutes sur les sucres et sur les produits allégés, avec deux étiquettes à comparer.

Astuce – Garder une trace pour le dossier

Notez dans le carnet de bord, après chaque séance, ce que l'évaluation formative a montré et ce que vous avez modifié. Ces traces sont la meilleure preuve de votre capacité d'**ajustement**, une compétence attendue par le référentiel : « Les tickets de sortie de l'atelier 3 montraient une confusion sur les produits allégés ; j'ai ajouté un exercice de comparaison à l'atelier 4. »

Attention – Formative ne veut pas dire notée

L'évaluation formative sert à **aider**, pas à classer. On ne relève pas les noms, on ne commente pas publiquement les erreurs individuelles, on valorise les bonnes réponses du groupe. Une personne qui se sent jugée risque de ne pas revenir.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.30

Pendant un atelier pour des adolescents, vous demandez à 16 participants de lever un carton : 6 verts, 7 orange, 3 rouges. a) Calculez la part de chaque couleur. b) Que faites-vous immédiatement ? c) Que notez-vous dans le carnet de bord ?

Corrigé

a) Verts : 6 / 16 = **37,5 %** ; orange : 7 / 16 = **43,8 %** ; rouges : 3 / 16 = **18,8 %**. b) Plus de la moitié du groupe n'est pas sûre ou n'a pas compris : on reprend la notion autrement (exemple concret, manipulation, explication par un pair qui a compris) avant de continuer, puis on vérifie à nouveau. c) La notion concernée, le résultat des cartons, l'ajustement réalisé et son effet (nouveau vote), ainsi qu'une idée pour la prochaine séance.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 9.3.9 – Évaluer l'animation et les outils

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois critères d'évaluation d'un support d'information.
2. Combien de personnes interroger pour prétester un support, et quelles questions leur poser ?
3. Pourquoi « 200 livrets distribués » n'est-il pas un résultat ?
4. Citez trois techniques d'évaluation formative en séance.
5. 10 participants sur 15 citent correctement un repère : quel pourcentage ?
6. Que faut-il noter dans le carnet de bord après une évaluation formative ?

Corrigé – Point d'étape 9.3.9

1. Compréhension, lisibilité, attractivité, acceptabilité, exactitude, utilisation (trois au choix).
2. Cinq à huit personnes du public visé ; « Qu'avez-vous compris ? », « Qu'est-ce qui vous a plu ou gêné ? », « Qu'allez-vous en faire ? ».
3. C'est une réalisation : il ne dit rien du changement chez le public.
4. Faire dire, cartons de couleur, ticket de sortie, mini-quiz, météo, démonstration (trois au choix).
5. 10 / 15 × 100 = 66,7 %.
6. Ce que l'évaluation a montré, l'ajustement réalisé et son effet, l'idée retenue pour la séance suivante.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 9.3.10.
3 ou 4 sur 6	Je relis le prétest et les techniques formatives.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 9.3.9 et je refais les exercices d'application.

9.3.10 Évaluer l'équité et les effets environnementaux

Module · Référentiel : C3.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 9.2.2)

L'équité : qui le projet a-t-il touché ?

Un projet peut atteindre ses objectifs en moyenne tout en bénéficiant surtout aux personnes les plus favorisées. Les **indicateurs d'équité** vérifient que le public prioritaire a bien été touché et qu'il a bénéficié des effets.

> **Exemple – Calcul détaillé : indicateurs d'équité d'un cycle d'ateliers municipal**
>
> Ateliers ouverts à toute la commune : 48 participants, dont 14 habitant le quartier prioritaire (qui représente 28 % de la population). Progression moyenne du score de connaissances : 2,9 points chez les participants du quartier prioritaire, 1,8 point chez les autres.
>
> - Part des participants du quartier prioritaire : 14 / 48 × 100 = **29,2 %**, soit un niveau proche de son poids dans la population (28 %) : **indice de représentation** = 29,2 / 28 = **1,04** (1 = représentation proportionnelle ; selon l'universalisme proportionné, on viserait plutôt une sur-représentation, supérieure à 1).
> - Les participants du quartier prioritaire progressent davantage (2,9 contre 1,8 point) : l'action contribue à **réduire** les écarts.

Les effets environnementaux

Avec la SNANC 2025-2030, les projets alimentaires intègrent de plus en plus des **indicateurs environnementaux** : réduction du gaspillage (pesée des restes), part de produits de saison, locaux ou sous signe de qualité, part de protéines végétales, empreinte carbone estimée des recettes (chapitre 4).

> **Exemple – Calcul détaillé : évolution du gaspillage dans un restaurant scolaire après une action**
>
> Pesée des restes pendant 5 jours avant et après une action « anti-gaspi » : avant 312 kg pour 2 400 repas ; après 218 kg pour 2 350 repas.
>
> - Gaspillage par repas avant : 312 / 2 400 = **0,130 kg** (130 g) ; après : 218 / 2 350 = **0,0928 kg** (92,8 g).
> - Réduction par repas : 130 − 92,8 = **37,2 g**, soit 37,2 / 130 × 100 = **28,6 %**.
> - On rapporte les restes au nombre de repas pour neutraliser la variation de fréquentation (2 400 et 2 350).

Évaluer l'accessibilité : qui n'est pas venu, et pourquoi ?

L'équité ne se juge pas seulement sur les participants. Les personnes qui **ne sont pas venues** disent beaucoup de l'action : si ce sont surtout les plus éloignées (horaires de travail, langue, transport, garde d'enfants, numérique), l'action risque d'accroître les inégalités. Évaluer l'accessibilité, c'est rechercher ces **barrières**.

Barrière	Exemples d'indices	Ajustements possibles
Information	Les non-participants ignoraient l'existence de l'action	Relais de confiance, bouche-à-oreille, affichage dans les lieux fréquentés
Horaires	Faible participation des personnes qui travaillent	Créneaux variés (soir, samedi), séances plus courtes
Distance et transport	Participants surtout proches du lieu	Séances délocalisées, navette, covoiturage

Barrière	Exemples d'indices	Ajustements possibles
Coût	Abandon quand une participation financière est demandée	Gratuité, ingrédients fournis
Langue et littératie	Peu de participants allophones ou peu lecteurs	Supports imagés, interprète, pairs relais
Garde d'enfants	Peu de parents de jeunes enfants	Accueil des enfants pendant la séance, activité parents-enfants
Numérique	Inscription uniquement en ligne	Inscription en face à face ou par téléphone
Image de l'action	« Ce n'est pas pour moi », peur d'être jugé	Nom et message non stigmatisants, convivialité

Exemple – Calcul détaillé : interroger les non-participants

Un programme d'ateliers (fictif) visait les familles d'un quartier prioritaire. À la fin du premier cycle, l'équipe téléphone à 60 familles du public visé qui ne sont pas venues et leur demande la raison principale. Réponses : horaires incompatibles **21** (21 / 60 = **35 %**) ; pas informées **18** (**30 %**) ; pas de solution de garde **12** (**20 %**) ; pas intéressées **9** (**15 %**). Les trois premières raisons, soit 85 % des réponses, sont des barrières sur lesquelles l'équipe peut agir. Le cycle suivant propose un créneau le samedi matin avec un accueil des enfants, et une information par l'école et la PMI.

Des indicateurs d'équité simples

Indicateur	Calcul	Lecture
Couverture par sous-groupe	participants du sous-groupe / public cible du sous-groupe × 100	Compare la capacité de l'action à toucher chaque sous-groupe
Part du sous-groupe prioritaire parmi les participants	participants prioritaires / total des participants × 100	À comparer à sa part dans le public cible
Résultat par sous-groupe	personnes ayant atteint l'objectif / participants du sous-groupe × 100	Vérifie que l'action réussit aussi chez les plus éloignés
Taux d'abandon par sous-groupe	abandons / inscrits du sous-groupe × 100	Repère les publics que l'action « perd » en route

Attention – Des effectifs suffisants

Un indicateur par sous-groupe n'a de sens que si chaque sous-groupe compte assez de personnes (au moins cinq, et de préférence davantage). Avec de petits effectifs, on regroupe les catégories ou l'on se contente d'une description qualitative.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.31

Dans un programme (fictif), 12 des 40 inscrits venaient du quartier prioritaire et 9 d'entre eux ont abandonné avant la fin ; parmi les 28 autres inscrits, 7 ont abandonné. a) Calculez la part des inscrits venant du quartier prioritaire et le taux d'abandon dans chaque sous-groupe. b) Interprétez et proposez deux pistes d'investigation.

Corrigé

a) Part du quartier prioritaire : 12 / 40 = **30 %**. Abandons : quartier prioritaire 9 / 12 = **75,0 %** ; autres 7 / 28 = **25,0 %**. b) L'action recrute des familles du quartier prioritaire mais les **perd** trois fois plus souvent : elle n'est pas équitable. Pistes : appeler les familles qui ont abandonné pour connaître leurs raisons (horaires, contenu, coût, sentiment de ne pas être à sa place) ; analyser les séances où les abandons ont eu lieu (contenu, lieu,

changement d'horaire) et en discuter avec des relais du quartier.

Des indicateurs de durabilité pour les projets alimentaires

Les projets alimentaires sont de plus en plus évalués aussi sur leurs effets **environnementaux**. En restauration collective, la loi EGalim (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018) fixe, pour la restauration collective publique, un objectif d'au moins **50 %** de produits durables et de qualité, dont au moins **20 %** de produits biologiques, en valeur d'achat, depuis le 1er janvier 2022 ; la loi Climat et résilience du 22 août 2021 a étendu ces obligations à la restauration collective privée à partir de 2024 et a pérennisé un menu végétarien au moins une fois par semaine en restauration scolaire. Ces repères fournissent des indicateurs tout prêts pour un projet en restauration collective.

Indicateur	Calcul	Source
Part de produits durables et de qualité	achats durables et de qualité (y compris bio) / achats totaux × 100, en valeur	Factures, logiciel de gestion
Part de produits biologiques	achats bio / achats totaux × 100	Factures
Gaspillage par repas	restes pesés / nombre de repas	Pesées sur 5 jours (9.3.10)
Part de repas végétariens	repas végétariens / repas servis sur un cycle	Plans de menus
Émissions estimées par repas	somme (nombre de plats × facteur d'émission) / nombre de repas	Base Agribalyse de l'ADEME pour les facteurs réels

Exemple – Calcul détaillé : la part de produits durables d'une cuisine centrale

Une cuisine centrale (fictive) a acheté pour 180 000 € de denrées sur l'année : 30 600 € de produits biologiques et 41 400 € d'autres produits durables et de qualité. Part de bio : 30 600 / 180 000 × 100 = **17,0 %**. Part de produits durables et de qualité, bio compris : (41 400 + 30 600) / 180 000 × 100 = 72 000 / 180 000 × 100 = **40,0 %**. Pour atteindre 50 % et 20 %, il faudrait 90 000 € de produits durables, dont 36 000 € de bio, soit **18 000 €** de plus de produits durables, dont au moins **5 400 €** de bio supplémentaires (à budget constant, en remplacement d'autres achats).

Exemple – Calcul détaillé : estimer l'effet d'un plan de menus sur les émissions

Pour montrer la méthode, on utilise des facteurs d'émission **fictifs** par portion (en kg d'équivalent CO_2) : plat au bœuf 4,5 ; volaille 1,2 ; poisson 1,5 ; végétarien 0,5. Sur un cycle de 20 repas, le plan initial comprend 4 plats au bœuf, 8 à la volaille, 4 au poisson et 4 végétariens : 4 × 4,5 + 8 × 1,2 + 4 × 1,5 + 4 × 0,5 = 18 + 9,6 + 6 + 2 = **35,6 kg**, soit **1,78 kg** par repas. Le nouveau plan comprend 2 plats au bœuf, 7 à la volaille, 4 au poisson et 7 végétariens : 9 + 8,4 + 6 + 3,5 = **26,9 kg**, soit **1,35 kg** par repas, une baisse de (26,9 − 35,6) / 35,6 × 100 = **−24,4 %**. Dans un vrai projet, on remplace ces facteurs par ceux de la base Agribalyse, en citant la version utilisée.

Attention – Durabilité et qualité nutritionnelle vont ensemble

Augmenter les repas végétariens doit se faire en respectant l'équilibre nutritionnel (apports en protéines, en fer, en calcium), les règles de la restauration collective et l'acceptabilité par les convives. Un indicateur environnemental est toujours accompagné d'un indicateur de **consommation** (restes, satisfaction) : un plat végétarien peu mangé n'est durable ni pour la santé ni pour la planète.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.32

Un restaurant administratif (fictif) a acheté pour 64 000 € de denrées, dont 9 600 € de bio et 16 000 € d'autres produits durables et de qualité. Calculez les deux parts et dites si les objectifs de la loi EGalim sont

atteints.

Corrigé

Bio : 9 600 / 64 000 × 100 = **15,0 %** (objectif de 20 % non atteint). Produits durables et de qualité, bio compris : (16 000 + 9 600) / 64 000 × 100 = 25 600 / 64 000 × 100 = **40,0 %** (objectif de 50 % non atteint). Il manque 0,5 × 64 000 − 25 600 = **6 400 €** de produits durables, dont 0,2 × 64 000 − 9 600 = **3 200 €** de bio.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 9.3.10 – Équité et environnement

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez quatre barrières qui peuvent empêcher le public prioritaire de participer.
2. Pourquoi interroger les non-participants ?
3. Donnez deux indicateurs d'équité et leur calcul.
4. Quels objectifs la loi EGalim fixe-t-elle pour les achats de la restauration collective publique ?
5. Achats : 50 000 € dont 8 000 € de bio et 14 000 € d'autres produits durables. Calculez les deux parts.
6. Pourquoi faut-il associer un indicateur de consommation à un indicateur environnemental ?

Corrigé – Point d'étape 9.3.10

1. Information, horaires, distance, coût, langue et littératie, garde d'enfants, numérique, image de l'action (quatre au choix).
2. Pour connaître les barrières qui ont empêché leur participation et ajuster l'action afin qu'elle ne creuse pas les inégalités.
3. Couverture par sous-groupe (participants du sous-groupe / public cible du sous-groupe) ; résultat par sous-groupe ; taux d'abandon par sous-groupe ; part du sous-groupe prioritaire parmi les participants (deux au choix).
4. Au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits biologiques, en valeur d'achat.
5. Bio : 8 000 / 50 000 = 16,0 % ; durables bio compris : 22 000 / 50 000 = 44,0 %.
6. Parce qu'un plat plus durable mais peu consommé augmente le gaspillage et ne nourrit pas les convives.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 9.3.11.
3 ou 4 sur 6	Je relis les barrières d'accès et les indicateurs EGalim.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 9.3.10 et je refais les exercices d'application.

9.3.11 Présenter un projet et ses résultats à l'oral

Module · Référentiel : C3.1 · CNED : Essentiels M1 S2 §2 (p. 11 et 12)

Le diaporama de présentation

Règle	Application
Une idée par diapositive	Titre qui dit le message (« 75 % des familles cuisinent désormais les légumes secs »)
Peu de texte	6 lignes au plus, mots-clés, police d'au moins 24 points ; l'oral complète
Des visuels utiles	Graphique simple (avant/après), photo autorisée, schéma (arbre, Gantt)

Règle	Application
Une structure claire	Contexte et diagnostic, objectifs, actions, évaluation, analyse critique, perspectives
Des chiffres sourcés	Source et date en bas de diapositive
Le respect du temps	Environ 1 diapositive par minute ; répéter avec un chronomètre

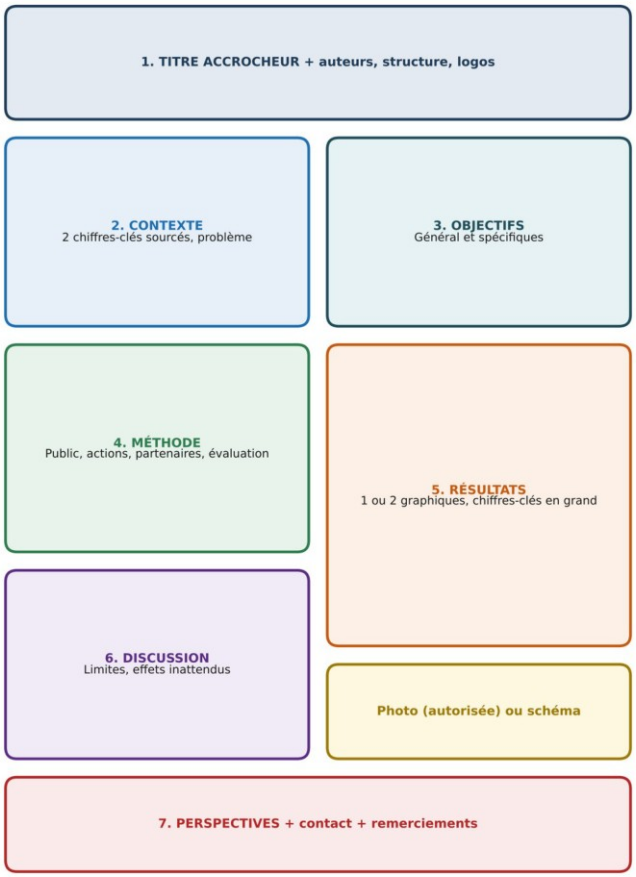


Figure 9.8 – La structure d'un poster professionnel

Méthode pas à pas – Préparer l'entretien avec un jury sur son projet

1. **Connaître ses chiffres** : population, constats, objectifs, résultats, budget (fiche mémo d'une page).
2. **Justifier chaque choix** : pourquoi ce problème (critères), ce public, ces actions, ces indicateurs.
3. **Identifier ses limites** et ce que l'on ferait autrement : un jury apprécie la lucidité.
4. **Relier aux compétences** du référentiel et aux savoirs (déterminants, littératie, éthique).
5. **S'entraîner** avec des questions types (voir les mises en situation express des chapitres 7 à 9) : réponse courte, structurée, illustrée par un exemple concret de **son propre** projet.
6. **Rester soi-même** : le jury évalue la compréhension et l'appropriation de la démarche ; un discours appris par cœur ou un dossier non maîtrisé se repère rapidement.

Répondre aux questions du jury sur l'évaluation

À l'oral, l'évaluation est l'une des parties les plus questionnées : le jury vérifie que vous comprenez vos chiffres, que vous connaissez leurs limites et que vous savez en tirer des décisions. Les questions reviennent souvent sous les mêmes formes.

Question type	Ce que le jury vérifie	Éléments d'une bonne réponse
« Comment avez-vous fixé votre cible ? »	La justification des objectifs	État initial, actions comparables ou repères, moyens du projet, validation par la structure
« Votre objectif est atteint : est-ce grâce à vous ? »	La compréhension des limites d'un avant / après	Évolution observée, autres facteurs possibles, absence de groupe de comparaison, éléments qui soutiennent le lien (verbatims, chronologie)
« Que pensez-vous de votre taux de réponse ? »	La lucidité sur les biais	Taux exact, profil probable des non-répondants, effet sur les résultats, ce que vous feriez autrement
« Votre objectif n'est pas atteint. Pourquoi ? »	La capacité d'analyse	Maillon de la chaîne en cause (mise en œuvre, contenu, cible trop ambitieuse), données à l'appui, ajustements proposés
« Que deviendra le projet après votre départ ? »	La pérennisation	Porteurs, outils, financement, calendrier
« Si c'était à refaire ? »	La posture réflexive	Deux ou trois changements précis, dont un sur l'évaluation

Méthode pas à pas – Structurer une réponse orale en trente secondes

1. Répondre directement à la question en une phrase (« Non, je ne peux pas l'affirmer avec certitude »).

2. Justifier avec un fait ou un chiffre de votre projet (« La part des familles est passée de 25 % à 75 %, mais sans groupe de comparaison »).

3. Nuancer ou compléter (« Les verbatims montrent toutefois que les familles citent les recettes des ateliers »).

4. Ouvrir si c'est utile (« Pour le prochain cycle, la liste d'attente pourrait servir de groupe de comparaison »).

Exemple – Deux réponses à la même question

Question : « Avec 9 répondants sur 15, vos résultats sont-ils fiables ? » Réponse faible : « Oui, parce que les participants étaient très motivés. » Réponse attendue : « Ils sont fragiles. 9 sur 15, c'est 60 % des participants ; les 6 qui n'ont pas répondu étaient absents au dernier atelier, et ce sont peut-être ceux qui ont le moins changé. Si je les compte tous comme n'ayant pas changé, la part finale passe de 67 % à 40 %. Je présente donc un résultat entre ces deux valeurs, et j'aurais dû prévoir une relance par téléphone. » (Calculs : 6 / 9 = 66,7 % ; 6 / 15 = 40,0 %.)

Attention – Ne pas défendre l'indéfendable

Si le jury relève une erreur réelle (un pourcentage faux, une conclusion abusive), le reconnaître simplement et corriger vaut mieux qu'une justification confuse. Le jury évalue la compréhension, pas l'absence d'erreur.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.33

Le jury vous demande : « Votre objectif de 60 % de présence n'est pas atteint (52 %). Était-il mal fixé ? » Rédigez une réponse structurée en quatre phrases, en imaginant des éléments plausibles de votre projet.

Corrigé

Exemple : « L'objectif n'était pas irréaliste, puisque des cycles comparables dans la structure atteignaient environ 65 % de présence. L'écart s'explique surtout par deux séances placées pendant les vacances scolaires,

où la présence est tombée à 30 %, alors qu'elle était de 60 % en moyenne sur les autres séances. J'aurais dû vérifier le calendrier scolaire avec la référente familles avant de fixer les dates. Pour le prochain cycle, nous avons programmé les séances hors vacances et ajouté un rappel par SMS la veille. »

Présenter l'évaluation en diapositives

Dans une présentation orale de projet, l'évaluation occupe en général deux ou trois diapositives. Elles doivent montrer la **méthode**, les **résultats** et leur **interprétation**, sans noyer l'auditoire sous les chiffres.

Diapositive	Contenu	Conseil
« Comment j'ai évalué »	Les indicateurs principaux, les outils, les moments, les effectifs	Un petit tableau ou un schéma du calendrier ; pas tout le plan d'évaluation
« Ce qui a changé »	Deux ou trois résultats clés, avant et après, comparés aux cibles	Un graphique en barres groupées, axe à zéro, effectifs ; titre qui donne le message
« Ce que j'en retiens »	Interprétation, limites, effets inattendus, décisions et suites	Trois ou quatre puces courtes ; une citation de participant si elle est parlante

Méthode pas à pas – Rédiger un titre-message

Un titre-message dit **ce que l'on doit retenir** de la diapositive, et non son sujet. Au lieu de « Résultats », écrire « 9 familles sur 12 cuisinent désormais les légumes secs chaque semaine ». Au lieu de « Limites », écrire « Des résultats encourageants, mais déclaratifs et sur un petit groupe ». Le jury comprend le message même s'il ne lit pas le reste.

Exemple – Le commentaire oral d'une diapositive de résultats

Diapositive : barres groupées « avant / après » pour trois indicateurs. Commentaire (environ une minute) : « Voici les trois résultats que je retiens. D'abord, la part des familles qui cuisinent des légumes secs au moins deux fois par semaine est passée de 3 à 9 familles sur 12 : la cible de 60 % est dépassée. Ensuite, le score moyen au quiz est passé de 4,8 à 7,2 sur 10, ce qui correspond presque à la moitié de la progression possible. Enfin, l'eau au goûter a doublé, de 4 à 8 familles. Ces résultats sont déclaratifs et portent sur 12 familles volontaires ; je les interprète donc comme une évolution encourageante, pas comme une preuve d'efficacité. »

Astuce – Prévoir des diapositives de réserve

Placez après la conclusion deux ou trois diapositives « de réserve » : le plan d'évaluation complet, le tableau de transition, le détail du budget. Vous ne les montrez que si le jury pose une question précise. Cela montre votre maîtrise sans surcharger la présentation.

Attention – Cohérence entre l'oral et le dossier

Les chiffres présentés à l'oral doivent être **exactement** ceux du dossier. Une différence (58 présences dans le dossier, 60 à l'oral) fait douter de toute l'évaluation. Relisez vos diapositives avec le dossier à côté.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.34

Transformez les titres suivants en titres-messages : a) « Participation » (taux de présence de 84 %, cible de 75 %) ; b) « Satisfaction » (23 répondants sur 25 satisfaits) ; c) « Limites » (pas de groupe de comparaison, mesure à la fin du cycle seulement).

Corrigé

a) « Une participation au-delà de la cible : 84 % de présence pour 75 % visés. » b) « 23 participants sur 25 se disent satisfaits des ateliers. » c) « Des résultats à confirmer : pas de groupe de comparaison et pas encore de recul. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 9.3.11 – Présenter à l'oral

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez les quatre étapes d'une réponse orale structurée.
2. Le jury demande si votre résultat est « grâce à vous ». Quels éléments citer ?
3. Qu'est-ce qu'un titre-message ? Donnez un exemple.
4. Combien de diapositives consacrer à l'évaluation, et avec quel contenu ?
5. À quoi servent les diapositives de réserve ?
6. Que faire si le jury relève une erreur réelle dans vos calculs ?

Corrigé – Point d'étape 9.3.11

1. Répondre directement, justifier par un fait, nuancer ou compléter, ouvrir.
2. L'évolution observée, les autres facteurs possibles, l'absence de groupe de comparaison, les éléments qui soutiennent le lien (verbatims, chronologie).
3. Un titre qui dit ce qu'il faut retenir ; par exemple « 9 familles sur 12 cuisinent désormais les légumes secs chaque semaine ».
4. Deux ou trois : la méthode, les résultats clés, l'interprétation avec les limites et les suites.
5. À répondre précisément à une question du jury (plan d'évaluation complet, tableau de transition, budget détaillé) sans surcharger la présentation.
6. Le reconnaître simplement et corriger.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 9.3.12.
3 ou 4 sur 6	Je relis les questions types du jury.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 9.3.11 et je refais les exercices d'application.

9.3.12 Le rapport d'évaluation : un modèle de plan commenté

Module · Référentiel : C3.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 9.2.2)

Le **rapport d'évaluation** (ou bilan) est destiné à la structure, aux partenaires et aux financeurs ; il peut être résumé dans une **synthèse** d'une page. Sa qualité tient à la clarté, à la cohérence avec le projet initial et à l'honnêteté de l'analyse.

Partie	Contenu et conseils
Synthèse (1 page)	Le projet en 5 lignes, 3 à 5 chiffres-clés, les recommandations principales ; c'est souvent la seule partie lue par les décideurs
Rappel du projet	Contexte, problème, objectifs (tels que formulés au départ), public, actions prévues
Méthode d'évaluation	Questions évaluatives, indicateurs, outils, calendrier de recueil, effectifs, limites prévisibles
Résultats de processus	Réalisations (prévu / réalisé), participation, profil des participants, budget (prévu / réalisé), écarts expliqués

Partie	Contenu et conseils
Résultats par objectif spécifique	Pour chaque objectif : valeur initiale, valeur finale, cible, taux d'atteinte, interprétation en 4 temps
Effets inattendus	Positifs et négatifs, avec exemples
Analyse selon les critères	Pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact, durabilité
Limites de l'évaluation	Biais, effectifs, absence de comparaison, recul
Conclusions et recommandations	3 à 6 recommandations concrètes, hiérarchisées, avec responsables possibles
Annexes	Outils (questionnaires, grilles), tableaux détaillés, compte rendu financier

Exemple – La synthèse d'une page du projet des Tilleuls (extrait)

« **Bien manger, petit budget, grand plaisir** (centre social des Tilleuls, mars-mai 2028) : 6 ateliers culinaires et une visite du marché pour 12 familles d'un quartier prioritaire, en partenariat avec l'épicerie solidaire. **Participation** : 80,6 % (58 présences sur 72). **Résultats** : familles consommant des légumes secs au moins 2 fois par semaine : 25 % → 75 % (objectif 60 %) ; score moyen de connaissances : 4,75 → 7,17 / 10 (objectif 7) ; satisfaction : 92 %. **Coût** : 3 590,90 €, dont 42,7 % financés par l'ARS. **Limites** : 12 familles volontaires, données déclaratives, recul de 3 mois. **Recommandations** : 1) reconduire deux cycles par an avec les mamans relais formées ; 2) étendre le partenariat avec l'épicerie (produits des recettes en rayon) ; 3) mesurer le maintien à 3 mois ; 4) porter au CLS la question de l'offre alimentaire du quartier. »

Attention – Les recommandations

Une recommandation est **concrète** (« deux cycles par an » plutôt que « continuer »), **fondée** sur un résultat de l'évaluation, **réaliste** et, si possible, **adressée** à un acteur. C'est la partie qui donne son utilité à l'évaluation.

Des résultats aux recommandations

Les recommandations sont la partie la plus utile du rapport : c'est elle que lisent les décideurs. Une bonne recommandation découle d'un **constat** de l'évaluation, propose une **action concrète**, désigne un **responsable** possible et un **délai**.

Méthode pas à pas – Construire une recommandation

1. Partir d'un constat chiffré ou qualitatif : « Deux séances pendant les vacances scolaires ont réuni 30 % des inscrits, contre 60 % en moyenne. »

2. En tirer une cause probable : « Le calendrier ne tenait pas compte des vacances. »

3. Proposer une action précise : « Programmer les séances hors vacances scolaires. »

4. Désigner un acteur et un délai : « La référente familles, pour le cycle de l'automne. »

5. Indiquer comment vérifier : « Taux de présence par séance. »

Constat	Recommandation	Acteur	Délai
Présence faible pendant les vacances scolaires	Programmer les séances hors vacances	Référente familles	Cycle d'automne
3 familles sur 12 citent le prix des légumes frais comme frein	Négocier avec l'épicerie un panier « recettes du mois » à prix réduit	Direction et épicerie solidaire	D'ici 3 mois
Recettes jugées trop longues par les parents qui travaillent	Ajouter deux recettes en moins de 20 minutes par cycle	Diététicienne	Prochain cycle

Constat	Recommandation	Acteur	Délai
Aucune mesure du maintien	Prévoir un appel à 3 mois avec 4 questions	Stagiaire suivant ou référente	3 mois après le cycle

Hiérarchiser les recommandations

Quand les recommandations sont nombreuses, on les classe selon leur **utilité** (effet attendu sur les résultats) et leur **faisabilité** (coût, temps, accord des acteurs). On commence par celles qui sont à la fois utiles et faciles ; on planifie celles qui sont utiles mais difficiles ; on abandonne celles qui sont peu utiles et difficiles.

	Faisabilité forte	Faisabilité faible
Utilité forte	À faire tout de suite (changer le calendrier)	À planifier (créer un accueil des enfants)
Utilité faible	À faire si le temps le permet (changer la couleur des affiches)	À abandonner

Attention – Pas de recommandation sans constat

« Développer le partenariat » ou « continuer le projet » ne sont pas des recommandations : elles ne disent ni pourquoi, ni quoi faire, ni qui. Chaque recommandation doit pouvoir être reliée à un résultat de l'évaluation, que le lecteur retrouve dans le rapport.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.35

À partir des constats suivants, rédigez deux recommandations complètes (constat, action, acteur, délai, indicateur) : a) 6 inscrits sur 20 n'ont jamais trouvé la salle, située au 3e étage sans signalétique ; b) les enfants ont refusé 4 recettes sur 6 lors des dégustations.

Corrigé

a) Constat : 6 inscrits sur 20 (30 %) ne sont jamais venus, en partie faute de trouver la salle. Action : installer une signalétique depuis l'entrée et accueillir les participants à l'accueil lors de la première séance. Acteur : agent d'accueil de la structure. Délai : avant le prochain cycle. Indicateur : nombre d'inscrits présents à la première séance. b) Constat : 4 recettes sur 6 refusées par les enfants. Action : tester les recettes avec un petit groupe d'enfants avant le cycle et proposer des préparations à composer soi-même. Acteur : diététicienne et animateurs. Délai : préparation du prochain cycle. Indicateur : part des enfants qui goûtent et terminent leur portion.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 9.3.12 – Le rapport d'évaluation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle partie du rapport est souvent la seule lue par les décideurs ?
2. Citez les cinq éléments d'une recommandation complète.
3. Pourquoi « continuer le projet » n'est-il pas une recommandation ?
4. Selon quels deux critères hiérarchise-t-on les recommandations ?
5. Que fait-on d'une recommandation utile mais difficile à mettre en œuvre ?
6. Citez quatre rubriques du rapport d'évaluation.

Corrigé – Point d'étape 9.3.12

1. La synthèse d'une page.

2. Un constat, une cause probable, une action précise, un acteur et un délai, un indicateur de vérification.
3. Parce qu'elle ne dit ni pourquoi, ni quoi changer, ni qui agit ; elle n'est reliée à aucun constat.
4. L'utilité (effet attendu) et la faisabilité (coût, temps, accord des acteurs).
5. On la planifie.
6. Synthèse, rappel du projet, méthode d'évaluation, résultats de processus, résultats par objectif, effets inattendus, analyse selon les critères, limites, recommandations, annexes (quatre au choix).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 9.3.13.
3 ou 4 sur 6	Je relis la construction des recommandations.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 9.3.12 et je refais les exercices d'application.

9.3.13 Évaluer à distance : mesurer le maintien des changements

Module · Référentiel : C3.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 9.2.2)

Les changements observés en fin d'action peuvent s'estomper. Une mesure **à distance** (1, 3 ou 6 mois après) renseigne sur le **maintien** (dimension M de RE-AIM, 9.3.4) et renforce la crédibilité de l'évaluation.

Méthode pas à pas – Organiser un recueil à distance

1. Prévoir dès l'inscription l'accord des participants pour être recontactés (case à cocher, coordonnées conservées séparément et supprimées ensuite : RGPD, chapitre 6).

2. Choisir quelques questions courtes, identiques à celles du questionnaire final (comparabilité).

3. Choisir le mode : appel téléphonique (meilleur taux de réponse auprès des publics éloignés du numérique), message, rencontre lors d'un temps fort.

4. Calculer le taux de réponse et analyser les réponses appariées.

5. Interpréter avec prudence : les personnes qui répondent à distance sont souvent les plus impliquées.

Exemple – Calcul détaillé : le maintien à 3 mois dans le projet des Tilleuls

Sur les 12 familles, 10 ont accepté d'être recontactées ; 8 répondent à l'appel à 3 mois.

- Taux de réponse : 8 / 12 = **66,7 %** des familles (8 / 10 = **80 %** de celles qui avaient accepté).
- Légumes secs au moins 2 fois par semaine, chez ces 8 familles : fin du cycle **7 / 8** ; à 3 mois **6 / 8**.
- Maintien : 6 / 7 × 100 = **85,7 %** des familles qui avaient atteint le repère le maintiennent ; à 3 mois, 6 / 8 = **75 %** des répondants l'atteignent.
- Recettes refaites au cours du dernier mois : 7 familles sur 8 (**87,5 %**), en moyenne 2,4 recettes différentes.

Interprétation : le changement se maintient largement chez les répondants, mais 4 familles (2 refus et 2 non-réponses) échappent à la mesure ; on ne peut pas exclure que leur comportement soit moins favorable. On présente donc le résultat comme « chez 8 familles sur 12 ».

Attention – Ne pas confondre maintien et durabilité

Le **maintien** concerne les **personnes** (les changements tiennent-ils dans le temps ?) ; la **durabilité** (critère de l'OCDE) concerne aussi l'**action** (se poursuit-elle après la fin du financement ?). Le projet des Tilleuls répond aux deux : maintien mesuré à 3 mois, et nouveau cycle animé par les relais formés.

Évaluer la durabilité de l'action un an après

La mesure à distance (9.3.13) vérifie que les **personnes** ont maintenu leurs changements. La **durabilité** porte sur l'**action** elle-même : continue-t-elle après le départ du stagiaire et la fin du financement ? Sous quelle forme ? Avec quelle qualité ? Cette question intéresse particulièrement les financeurs, qui veulent savoir si leur investissement a laissé une trace.

Dimension	Indicateur possible	Source
Continuité	Nombre de cycles réalisés par l'équipe sur l'année / nombre prévu	Planning, carnet de bord
Fidélité	Les fonctions clés sont-elles conservées (méthodes actives, participation du public) ?	Observation d'une séance, entretien avec les animateurs
Participation	Places occupées / places offertes	Feuilles d'émargement
Ressources	Financement assuré pour l'année suivante ; personnes formées toujours en poste	Budget, organigramme
Diffusion	Autres structures qui ont repris l'action ou les outils	Demandes reçues, échanges
Évaluation continuée	L'équipe utilise-t-elle encore les outils d'évaluation ?	Bilans des cycles

Exemple – Calcul détaillé : le bilan de durabilité à un an

Un projet d'ateliers culinaires (fictif) a été repris par deux animatrices formées pendant le stage. Un an après, le bilan indique : **5 cycles réalisés sur 8 prévus** (5 / 8 = **62,5 %**) ; 46 places occupées sur 60 offertes (46 / 60 = **76,7 %**) ; méthodes actives conservées, mais les dégustations avec les enfants ont été supprimées « par manque de temps » ; une animatrice sur deux a quitté la structure ; le financement de l'année suivante n'est assuré qu'à moitié ; le questionnaire de fin de cycle n'est plus utilisé.

Lecture : l'action continue, avec une bonne participation, mais elle est **fragilisée** : trois cycles sur huit n'ont pas eu lieu, une fonction clé (les dégustations, qui agissaient sur l'acceptation par les enfants) a disparu, et l'action dépend désormais d'une seule personne. Recommandations : former une deuxième personne, réintroduire une dégustation courte à chaque séance, simplifier le questionnaire à quatre questions pour que l'équipe continue à évaluer.

Astuce – Penser la durabilité dans le dossier de stage

Même si vous ne pouvez pas mesurer la durabilité (le stage se termine avant), vous pouvez en **poser les conditions** et proposer les indicateurs que la structure suivra : « Dans un an, la structure pourra vérifier le nombre de cycles réalisés par l'équipe, la conservation des dégustations et l'utilisation du questionnaire court. » Le jury apprécie cette projection.

Attention – Une action qui dérive

Après le départ de son initiateur, une action peut rester active tout en perdant ce qui faisait son efficacité : des ateliers pratiques deviennent des exposés, la participation du public au choix des recettes disparaît. C'est pourquoi le transfert de l'action s'accompagne d'une liste écrite des **fonctions clés** à conserver (9.3.5).

À vous de jouer – Exercice d'application 9.36

Un an après un projet de « petits-déjeuners partagés » dans un collège (fictif), 18 séances ont eu lieu sur 30 prévues, avec 210 élèves présents pour 360 places offertes. Les élèves ambassadeurs n'ont pas été renouvelés à la rentrée. a) Calculez les deux taux. b) Jugez la durabilité de l'action. c) Proposez deux mesures.

Corrigé

a) Continuité : 18 / 30 = **60,0 %** ; occupation : 210 / 360 = **58,3 %**. b) L'action continue mais s'essouffle : moins de deux séances sur trois ont eu lieu et un peu plus de la moitié des places sont occupées ; la fonction clé « participation des élèves » s'est affaiblie avec le non-renouvellement des ambassadeurs. c) Recruter et former de nouveaux ambassadeurs à chaque rentrée, inscrit dans le calendrier du collège ; désigner un adulte référent responsable du planning et faire un point trimestriel avec l'infirmière.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 9.3.13 – Évaluer à distance

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la différence entre maintien et durabilité ?
2. Citez trois indicateurs de durabilité d'une action.
3. Pourquoi faut-il demander l'accord des participants pour les recontacter dès l'inscription ?
4. 12 participants avaient adopté un comportement ; 9 l'ont gardé à 3 mois. Calculez le taux de maintien.
5. Qu'est-ce qu'une action qui « dérive » ?
6. Que peut écrire le stagiaire sur la durabilité s'il ne peut pas la mesurer ?

Corrigé – Point d'étape 9.3.13

1. Le maintien concerne les changements chez les personnes ; la durabilité concerne la poursuite de l'action elle-même après la fin du financement ou le départ du porteur.
2. Cycles réalisés / prévus, conservation des fonctions clés, places occupées / offertes, financement assuré, personnes formées en poste, diffusion, évaluation continuée (trois au choix).
3. Pour respecter le RGPD et pouvoir mener légalement la mesure à distance.
4. 9 / 12 × 100 = 75,0 %.
5. Une action qui continue mais a perdu ce qui faisait son efficacité (méthodes actives, participation du public).
6. Les conditions de durabilité et les indicateurs que la structure pourra suivre.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 9.3.14.
3 ou 4 sur 6	Je relis la mesure à distance et la durabilité.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 9.3.13 et je refais les exercices d'application.

9.3.14 Fil rouge : l'évaluation et la valorisation du projet des Tilleuls

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 108 et 109 · CNED : pas de passage correspondant (voir 9.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès a fait

- **Plan d'évaluation** rédigé en février (fiche F12), avec l'état initial mesuré au premier atelier (7 mars).
- **Processus** : 6 ateliers sur 6 ; 58 présences sur 72 (80,6 %) ; visite du marché (9 familles) ; 12 livrets remis le 27 mai ; dépenses monétaires 3 092,90 € pour 3 060 € prévus (+ 1,1 %).
- **Résultats** : score moyen 4,75 → 7,17 (gain normalisé 0,46) ; légumes secs 25 % → 75 % ; eau au goûter 33 % → 67 % ; satisfaction 91,7 %.
- **Effets inattendus** : 4 familles ont créé un groupe d'achats de légumes secs en vrac ; une famille s'est sentie jugée lors d'un échange sur les sodas (Inès a revu sa formulation : chapitre 6).
- **Limites** : 12 familles volontaires, données déclaratives, pas de groupe de comparaison, recul de 3 mois

seulement.

- **Valorisation** : temps fort festif le 27 mai (45 personnes, buffet préparé par les familles) ; présentation au COPIL de juin ; article dans le journal municipal (photos de mains et de plats) ; note d'une page au comité du CLS ; poster présenté à la journée régionale de nutrition ; compte rendu financier à l'ARS (Cerfa n° 15059).
- **Pérennisation** : la référente familles et 2 mamans relais animent un nouveau cycle à l'automne avec les conducteurs d'Inès ; nouvelle demande déposée dans le cadre du CLS ; le centre social voisin a demandé les outils (adoption).

Fil rouge – centre social des tilleuls – Compléments : l'analyse fine des résultats du projet des Tilleuls

- **Tableau de transition** (légumes secs) : 6 familles sur les 9 qui pouvaient progresser l'ont fait (66,7 %), aucune n'a régressé.
- **Équité interne** : les 5 participants qui avaient moins de 5/10 au départ ont progressé de 2,8 points en moyenne, contre 2,1 pour les autres.
- **Qualitatif** : 9 participants sur 12 citent une recette de légumes secs qu'ils vont refaire ; le récit retenu comme « changement le plus significatif » par le groupe : une mère qui a cuisiné le dahl pour un repas de famille et en a transmis la recette.
- **Observation des séances** : score d'animation 22/32 à l'atelier 1, 29/32 à l'atelier 3 (amélioration de la gestion du temps de parole).
- **Environnement** : restes de denrées en fin d'atelier presque nuls (redistribués dans des boîtes) ; épluchures compostées au jardin partagé ; part de protéines végétales dans les plats principaux du cycle : 4 sur 6.
- **Présentation** : diaporama de 12 diapositives au comité de pilotage de juin, poster à la journée régionale de nutrition.

9.4 Approfondissements

9.4.1 L'évaluation participative

Associer les participants à l'évaluation (choix des critères, recueil, interprétation des résultats) produit des informations plus justes et renforce leur pouvoir d'agir. Exemples : les familles définissent elles-mêmes ce qu'est pour elles un « atelier réussi » ; restitution des résultats en groupe et discussion (« Qu'est-ce qui vous a le plus aidé ? ») ; photo-expression « ce qui a changé dans ma cuisine ». Cette démarche rejoint la Charte d'Ottawa et l'éthique du projet (chapitre 6).

Mettre en œuvre une évaluation participative

L'évaluation participative (9.4.1) associe les participants à une ou plusieurs étapes : choisir les critères, recueillir les informations, interpréter les résultats, décider de la suite. Elle demande peu de moyens mais une animation soignée.

Étape	Exemple de participation	Méthode
Définir ce qu'est une réussite	Les participants disent ce qui comptera pour eux à la fin du cycle	Tour de table « Pour moi, ce cycle sera réussi si… »
Choisir les indicateurs	Le groupe retient trois indicateurs parmi ses propositions	Vote par gommettes
Recueillir	Les participants photographient leurs repas ou tiennent un petit carnet	Photo-expression, carnet illustré
Interpréter	Le groupe commente les résultats présentés	Restitution et discussion

Étape	Exemple de participation	Méthode
Décider	Le groupe propose des améliorations pour le cycle suivant	Arbre à idées, priorisation collective

Exemple – Des critères de réussite choisis par les participants

Dans un groupe de femmes d'un centre social (fictif), l'équipe avait prévu deux indicateurs : la consommation de légumes et le score au quiz. Au tour de table du premier atelier, les participantes proposent d'autres critères : « réussir à faire manger des légumes à mes enfants sans bagarre », « dépenser moins à la fin du mois », « sortir de chez moi une fois par semaine ». Le groupe retient trois critères par un vote : les enfants mangent les légumes proposés (11 votes sur 14), les dépenses alimentaires de la semaine (9 votes), le plaisir de se retrouver (8 votes). L'équipe ajoute ces critères à son plan d'évaluation ; à la fin du cycle, les participantes les évaluent elles-mêmes sur une échelle de 1 à 5 et en discutent.

Méthode pas à pas – La photo-expression comme outil d'évaluation

1. Expliquer la consigne au premier atelier : « Prenez en photo un repas que vous avez préparé cette semaine. » Préciser : pas de visage, pas de personne identifiable.

2. Recueillir les photos au début et à la fin du cycle, avec l'accord des participants.

3. Les faire commenter par leur auteur : « Qu'est-ce que cette photo dit de votre cuisine ? Qu'est-ce qui a changé ? »

4. Analyser avec le groupe : légumes visibles, plats faits maison, nouveaux aliments.

5. Utiliser les photos dans la restitution et, avec un accord écrit, dans la valorisation.

Attention – Participer n'est pas obligatoire

Certaines personnes ne souhaitent pas photographier leur cuisine ou parler de leurs dépenses. L'évaluation participative propose, elle n'impose pas : chaque outil a une alternative (décrire plutôt que photographier, répondre seul plutôt qu'en groupe), et l'on respecte le refus.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.37

Proposez deux façons d'associer des adolescents d'un foyer éducatif (fictif) à l'évaluation d'un projet sur le petit-déjeuner, en précisant à quelle étape chacune intervient.

Corrigé

Exemples : au début, les jeunes définissent ce qu'est pour eux un « bon petit-déjeuner » et choisissent les indicateurs avec l'équipe (étape « définir la réussite et les indicateurs ») ; pendant le projet, deux jeunes volontaires relèvent chaque matin, avec un éducateur, le nombre de jeunes qui prennent un petit-déjeuner sur une grille simple (étape « recueillir ») ; à la fin, le groupe commente les résultats et propose des changements (étape « interpréter et décider »).

9.4.2 Les données probantes en prévention

Le **portail des interventions efficaces ou prometteuses** de Santé publique France classe des programmes selon le niveau de preuve de leur efficacité ; il s'appuie sur des évaluations rigoureuses. Une action de terrain évaluée, même modestement, peut contribuer à cette connaissance si son évaluation est **documentée** (méthode, résultats, limites) et **diffusée** (capitalisation). À l'inverse, s'inspirer d'un programme probant impose de respecter

ses **fonctions clés** (nombre de séances, méthodes actives, implication des familles), sous peine de perdre son efficacité.

Lire l'évaluation d'une intervention publiée

Avant de construire un projet, on cherche si des actions comparables ont été **évaluées**. Le répertoire des interventions efficaces ou prometteuses de Santé publique France, le portail de capitalisation CAPS ou des articles scientifiques en présentent. Encore faut-il savoir les lire de façon critique.

Question à se poser	Pourquoi
Quel était le public et le contexte ?	Une action efficace auprès d'enfants scolarisés ne l'est pas forcément auprès de personnes âgées
Quel plan d'évaluation a été utilisé ?	Un essai avec groupe de comparaison donne plus de confiance qu'un simple avant / après
Quels indicateurs ont été mesurés ?	Des connaissances ou des comportements ? Déclarés ou observés ?
Combien de personnes, combien de perdus de vue ?	Les petits effectifs et les abandons nombreux fragilisent les conclusions
Quelle durée de suivi ?	Un effet à la fin de l'action peut disparaître à six mois
Quelles sont les fonctions clés de l'intervention ?	Ce qu'il faut conserver si l'on s'en inspire
Qui a mené et financé l'évaluation ?	Repérer d'éventuels conflits d'intérêts
Quand a-t-elle été publiée ?	Le contexte et les connaissances évoluent ; dater la source

Les niveaux de preuve en quelques mots

On classe souvent les évaluations selon la confiance que l'on peut accorder à leurs conclusions. Du plus faible au plus fort : l'avis d'experts et le retour d'expérience ; l'avant / après sans comparaison ; l'avant / après avec groupe de comparaison ; l'essai contrôlé randomisé ; la synthèse de plusieurs essais (revue systématique). En promotion de la santé, où les interventions sont complexes et dépendent du contexte, les évaluations qualitatives et les expériences capitalisées complètent utilement ces classements.

Exemple – Analyser une fiche d'intervention (fictive)

Fiche : « Programme d'ateliers cuisine pour familles, 8 séances, évalué dans 12 centres sociaux ; 240 familles, dont 180 suivies jusqu'au bout ; groupe de comparaison de 6 centres sur liste d'attente ; consommation de légumes déclarée : + 0,6 portion par jour chez les participants contre + 0,1 dans le groupe de comparaison à la fin du programme ; pas de mesure à six mois ; évaluation financée par le promoteur du programme. »
Lecture : le plan est solide (groupe de comparaison) et l'effet estimé est d'environ 0,6 − 0,1 = **0,5 portion par jour** ; mais 60 familles sur 240 (**25 %**) sont perdues de vue, la mesure est déclarative, le maintien n'est pas connu et l'évaluation n'est pas indépendante. On peut s'en inspirer en conservant ses fonctions clés, en restant prudent sur l'ampleur de l'effet attendu.

Attention – Une source sans date ne vaut rien

Dans votre dossier, chaque référence à une intervention ou à une évaluation est **datée** et **sourcée** (auteur ou organisme, titre, année, lien et date de consultation pour une page en ligne). Le jury vérifie que vos arguments s'appuient sur des sources identifiables et récentes.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.38

Une association vous présente un programme « qui marche à coup sûr » : « 98 % de participants satisfaits, testé auprès de 50 personnes ». Quelles questions posez-vous avant de vous en inspirer ?

Corrigé

La satisfaction n'est pas un résultat de santé : quels **changements** ont été mesurés chez les participants (connaissances, comportements), et comment ? Y avait-il une mesure **avant** et un **groupe de comparaison** ? Combien des 50 personnes ont répondu (perdus de vue) ? Quel était le **public** et le contexte, et sont-ils proches du mien ? Quelle était la durée du suivi ? Qui a mené l'évaluation, et quand ? Quelles sont les fonctions clés du programme ?

9.4.3 Les effets indésirables d'une action de prévention

Une action de nutrition peut avoir des effets **non souhaités** : stigmatisation, culpabilisation, restriction cognitive, accroissement des inégalités si seules les familles favorisées en profitent (effet « Matthieu »). L'évaluation doit les rechercher activement (question ouverte « Y a-t-il quelque chose qui vous a gêné ? », observation, équité de la participation) : c'est une exigence de **non-malfaisance** (chapitre 6).

Repérer et prévenir les effets indésirables

Le principe de **non-malfaisance** (chapitre 6) impose de rechercher activement ce qu'une action de nutrition pourrait abîmer. Les effets indésirables sont rarement mesurés par les indicateurs prévus : il faut les anticiper dès la conception, puis les rechercher pendant l'évaluation.

Effet indésirable	Exemple	Prévention
Stigmatisation	Un atelier « pour les enfants en surpoids » désigne les enfants concernés	Actions ouvertes à tous, messages centrés sur le plaisir et la santé de tous
Culpabilisation	Des parents se sentent jugés sur ce qu'ils donnent à manger	Partir de leurs pratiques, valoriser ce qui va bien, éviter « bon » et « mauvais » aliment
Restriction et préoccupation excessive	Un adolescent se met à supprimer des aliments par peur de « mal manger »	Ne pas centrer les messages sur le poids ; repérer les signaux d'alerte et orienter
Effet de report	Après le retrait des sodas, les ventes de boissons énergisantes augmentent	Suivre toutes les ventes, pas seulement le produit retiré
Accroissement des inégalités	Seules les familles déjà favorisées participent et progressent	Indicateurs d'équité, universalisme proportionné
Gaspillage	Fruits distribués non consommés et jetés	Pesée des restes, portions adaptées, choix des fruits
Surcharge des équipes	L'action repose sur des agents déjà débordés	Évaluer la charge de travail, prévoir des moyens
Exclusion	Des recettes inadaptées aux régimes religieux ou aux allergies excluent certains participants	Recueillir les contraintes alimentaires, proposer des alternatives

Méthode pas à pas – Rechercher les effets indésirables

1. Anticiper : avant l'action, lister avec l'équipe et quelques personnes du public « ce qui pourrait mal tourner ».

2. Prévoir des indicateurs d'alerte : ventes de produits de substitution, abandons, plaintes, restes.

3. Poser une question ouverte dans chaque bilan : « Y a-t-il quelque chose qui vous a gêné ou mis mal à l'aise ? »

4. Observer : moqueries, mise à l'écart, refus, signes de malaise.

5. Réagir : modifier l'action dès qu'un effet indésirable apparaît, et le mentionner dans le bilan.

Exemple – Un effet indésirable repéré à temps

Dans un projet « Défi goûter » en école élémentaire (fictif), un tableau affiché en classe indiquait chaque jour le nom des élèves qui avaient apporté un goûter « validé ». Au bout de deux semaines, une enseignante signale qu'un élève ne veut plus sortir son goûter devant les autres, et qu'une maman s'est plainte de se sentir jugée. L'équipe remplace le tableau nominatif par un compteur collectif de la classe (« Aujourd'hui, nous avons 14 fruits ! ») et adresse aux familles un message centré sur les idées de goûters, sans liste d'aliments interdits. Le bilan mentionne l'effet indésirable et l'ajustement.

Attention – Signaler, ce n'est pas avouer un échec

Un bilan qui mentionne un effet indésirable et la manière dont il a été corrigé montre une évaluation honnête et une équipe attentive. Le jury apprécie cette transparence ; il se méfie davantage d'un bilan où « tout s'est bien passé ».

À vous de jouer – Exercice d'application 9.39

Une entreprise (fictive) organise un « challenge des pas » entre services, avec un classement affiché à la cafétéria et un atelier « manger moins gras ». Repérez trois effets indésirables possibles et proposez une prévention pour chacun.

Corrigé

Exemples : **stigmatisation et pression** sur les salariés moins mobiles (handicap, maladie, âge) ou sur les services moins bien classés : remplacer le classement par un objectif collectif de l'entreprise et proposer des activités variées ; **culpabilisation** par un message centré sur le « gras » : parler de plaisir, d'équilibre et de repas complets ; **exclusion** des salariés en poste de nuit ou à temps partiel, qui ne peuvent pas participer aux horaires prévus : adapter les horaires et le format.

9.4.4 Le coût de l'évaluation et sa proportionnalité

Une évaluation demande du **temps** (conception des outils, recueil, saisie, analyse, rédaction) : on recommande souvent d'y consacrer de l'ordre de **5 à 10 %** des ressources d'un projet. Elle doit être **proportionnée** : un cycle de 6 ateliers ne justifie pas un questionnaire de 40 questions ; quelques indicateurs bien choisis, recueillis rigoureusement, valent mieux qu'une masse de données inexploitées. Dans le projet des Tilleuls, Inès a consacré 16 heures sur 130 à l'évaluation (16 / 130 = 12,3 % de son temps de stage sur le projet), ce qui est cohérent avec un projet où l'évaluation est aussi un objectif de formation.

Chiffrer le temps et le coût de l'évaluation

L'évaluation est souvent oubliée dans le budget du projet, puis réalisée « à la va-vite ». La chiffrer dès la conception permet de lui réserver du temps et de vérifier qu'elle reste **proportionnée** (9.4.4).

Exemple – Calcul détaillé : le budget-temps de l'évaluation d'un cycle d'ateliers

Projet fictif de 7 800 €. Temps prévu pour l'évaluation, en heures : conception du questionnaire et de la grille d'observation **6** ; prétest et corrections **4** ; recueil initial **3** ; recueil final et observation **8** ; saisie et contrôle **6** ; analyse et rédaction du bilan **5**. Total : 6 + 4 + 3 + 8 + 6 + 5 = **32 heures**. Au coût horaire chargé de 22 € : 32 × 22 = **704 €**, soit 704 / 7 800 × 100 = **9,0 %** du budget du projet, dans la fourchette souvent recommandée de 5 à 10 % (soit ici 390 à 780 €).

Poste de l'évaluation	Comment réduire le temps sans perdre en qualité
Conception des outils	Partir d'outils existants et validés, les adapter
Recueil	Intégrer le questionnaire à une séance plutôt que de le faire remplir à la maison
Saisie	Questionnaire court ; saisie directe sur tablette ou formulaire si le public s'y prête
Analyse	Préparer le tableur avant le recueil, avec les formules
Rédaction	Rédiger la méthode dès le début, compléter les résultats à la fin

Attention – Le temps de l'évaluation est un temps de travail

Le temps passé à évaluer figure dans le budget (charges de personnel ou contribution en nature) et dans le planning (diagramme de Gantt, chapitre 8). Un projet qui prévoit une évaluation sans lui affecter de temps ne pourra pas la réaliser correctement.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.40

Pour un projet de 12 000 €, une stagiaire prévoit 70 heures d'évaluation à 20 € de l'heure. a) Calculez le coût de l'évaluation et sa part dans le budget. b) Est-ce proportionné ? c) Proposez deux économies de temps.

Corrigé

a) 70 × 20 = **1 400 €**, soit 1 400 / 12 000 × 100 = **11,7 %** du budget. b) C'est un peu au-dessus de la fourchette habituelle de 5 à 10 % (600 à 1 200 €) : acceptable si l'évaluation est aussi un objectif de formation ou si le financeur demande une évaluation approfondie, sinon à alléger. c) Réduire le questionnaire aux questions liées aux indicateurs ; remplacer une partie des entretiens individuels par un entretien collectif ; préparer le tableur à l'avance.

9.4.5 Évaluation et apprentissage organisationnel

Au-delà du jugement, l'évaluation sert l'**apprentissage** d'une organisation : identifier ce qui marche, comprendre pourquoi, ajuster les pratiques (cycle PDCA de Deming, chapitre 8). Les structures qui pratiquent régulièrement l'auto-évaluation (par exemple avec le guide d'autoévaluation de l'INPES) améliorent progressivement la qualité de leurs actions. Pour le diététicien, l'habitude de documenter ses actions (conducteurs, bilans, indicateurs) est une compétence professionnelle durable.

Le retour d'expérience en équipe

À la fin d'un projet, une réunion de **retour d'expérience** réunit l'équipe et les partenaires pour tirer les leçons de l'action, au-delà des indicateurs. Elle prend une heure environ et nourrit les recommandations, la fiche de capitalisation et l'apprentissage de la structure.

Méthode pas à pas – Animer un retour d'expérience avec la méthode des quatre cases

1. **Présenter rapidement** les principaux résultats de l'évaluation (dix minutes).
2. **Faire remplir quatre cases** sur un grand tableau, avec des papiers adhésifs : « Ce qui a bien marché », « Ce qui a moins bien marché », « Ce que nous garderons », « Ce que nous changerons ».
3. **Regrouper** les idées semblables et les discuter.
4. **Choisir** trois décisions concrètes, avec un responsable et un délai.
5. **Rédiger** un compte rendu court, diffusé à tous les participants de la réunion.

Exemple – Extrait du compte rendu d'un retour d'expérience (fictif)

Ce qui a bien marché : le binôme diététicienne et conseillère en économie sociale et familiale ; les recettes choisies avec les familles ; le partenariat avec l'épicerie. **Ce qui a moins bien marché** : l'information des familles par affichage ; le questionnaire trop long ; deux séances pendant les vacances. **Ce que nous garderons** : le choix des recettes par le groupe ; la dégustation finale. **Ce que nous changerons** : information par les relais et l'école ; questionnaire de huit questions ; calendrier vérifié avec les vacances scolaires. **Décisions** : la conseillère prépare le calendrier du prochain cycle avant le 15 septembre ; la diététicienne réduit le questionnaire avant le 30 juin ; la directrice présente le bilan au comité du contrat local de santé en octobre.

Astuce – Le retour d'expérience nourrit le dossier de stage

Le compte rendu de la réunion est une source précieuse pour l'analyse critique du dossier (9.3.6) : il montre que les conclusions ont été partagées avec l'équipe, et il apporte des regards complémentaires au vôtre. Pensez à le joindre en annexe.

À vous de jouer – Exercice d'application 9.41

Lors d'un retour d'expérience, deux partenaires s'opposent : l'un veut « tout arrêter » parce que la participation a été faible, l'autre veut « tout garder » parce que les participants étaient très satisfaits. Comment l'évaluation peut-elle aider à trancher ?

Corrigé

En revenant aux **données** et aux **critères** : l'efficacité chez les participants (objectifs atteints ou non), la participation et ses causes (barrières repérées chez les non-participants), l'équité, le coût par participant. Si l'action est efficace mais touche peu de monde à cause de barrières identifiées, la décision la plus logique est de l'**ajuster** (horaires, information, lieu) plutôt que de l'arrêter ou de la garder telle quelle. La grille de jugement (9.3.4) rend la discussion plus objective.

9.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Tester une évolution avant/après : les tests appariés

Avec des mesures **appariées** (mêmes personnes avant et après), on utilise des tests adaptés. **Variable quantitative** (score) : **test t de Student apparié** sur les différences. Projet des Tilleuls : différences après − avant : 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2 ; moyenne $\bar{d}$ = 29 / 12 = **2,417** ; écart-type s = **0,515** ; erreur type : 0,515 / √12 = 0,515 / 3,464 = **0,1487** ; t = 2,417 / 0,1487 = **16,3** pour 11 degrés de liberté, bien supérieur au seuil de 2,20 (= 5 %) : la progression est **statistiquement significative**. α **Variable binaire** (légumes secs oui/non) : **test de McNemar**, fondé sur les seules paires **discordantes**. Si les 3 familles « oui » avant le restent après et que 6 familles passent de « non » à « oui » (b = 6, c = 0), le test exact donne p = 2 × 0,5 = 2 × 0,015625 = **0,031** < 0,05 : changement significatif. [6] **Prudence** : « significatif » signifie peu probable d'être dû au hasard, **pas** dû à l'action ; sans groupe de comparaison, d'autres explications restent possibles.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Évaluation réaliste et théorie du programme

L'**évaluation réaliste** (Pawson et Tilley, 1997) ne demande pas seulement « est-ce que ça marche ? » mais « **qu'est-ce qui marche, pour qui, dans quelles circonstances, et pourquoi ?** ». Elle formule des configurations **contexte – mécanisme – effet** (CME) : dans un quartier où les familles se connaissent (contexte), cuisiner

ensemble crée de la confiance et de l'imitation (mécanisme), ce qui augmente l'adoption de nouvelles recettes (effet). Cette approche est particulièrement adaptée aux interventions complexes en promotion de la santé.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Taille d'effet et puissance

La **taille d'effet** mesure l'ampleur d'un changement indépendamment de la taille de l'échantillon ; pour un test apparié, d de Cohen = $\bar{d}$ / s = 2,417 / 0,515 = **4,7**, valeur très élevée (au-delà de 0,8, l'effet est dit « grand »), en partie parce que le questionnaire mesure des connaissances directement enseignées. La **puissance** est la probabilité de détecter un effet réel : avec de petits effectifs, un effet modeste peut passer inaperçu ; l'absence de différence significative ne prouve pas l'absence d'effet.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La régression vers la moyenne

Quand on sélectionne des personnes parce qu'elles ont un score **extrême** (très bas) lors d'une première mesure, leur score suivant tend à se rapprocher de la moyenne, même sans intervention, en raison des fluctuations aléatoires de la mesure : c'est la **régression vers la moyenne**. Une partie de la forte progression des participants « les plus faibles » (9.3.7) peut donc être un artefact. Seul un **groupe de comparaison** sélectionné de la même façon permet de distinguer l'effet de l'action de cet effet statistique.

9.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Évaluer l'éducation thérapeutique

Un programme d'éducation thérapeutique du patient fait l'objet d'une auto-évaluation annuelle et d'une évaluation quadriennale transmise à l'ARS : le diététicien y apporte les indicateurs de processus (séances, participants) et de résultats (compétences acquises).

Situation bc2 – Évaluer une action anti-gaspillage

Après une campagne en restauration scolaire, le diététicien compare les pesées de restes avant et après (en grammes par convive), calcule la variation relative et l'économie réalisée, et présente les résultats en commission des menus.

Situation bc3 – Un bilan pour l'ARS

À la fin d'un projet financé par le FIR, le diététicien rédige le bilan d'activité et le compte rendu financier, explique les écarts, présente les indicateurs de processus et de résultats et propose des perspectives de reconduction.

Situation bc3 – Des résultats décevants

Une évaluation montre que les connaissances ont progressé mais pas les comportements déclarés. Le diététicien analyse les causes (actions uniquement informatives, pas d'action sur l'environnement), en tire des recommandations (ateliers pratiques, partenariat avec l'épicerie) et les présente sans les masquer.

Situation bc2 – Évaluer une action anti-gaspillage

Le diététicien d'une cuisine centrale rapporte les restes au nombre de repas (g par repas), compare 5 jours avant et après, et présente la réduction en pourcentage et l'économie de denrées en commission des menus.

Situation bc3 – Une évaluation qualitative révélatrice

Les questionnaires d'un cycle sont très positifs, mais un groupe de parole de bilan révèle que plusieurs participantes n'osent pas refaire les recettes faute d'ustensiles. Le diététicien propose un kit ustensiles prêté par l'épicerie solidaire : un effet inattendu transformé en ajustement.

Cas guidé : évaluer le défi « Un fruit à la récré » d'une école élémentaire

Ce cas guidé reprend toutes les étapes du chapitre sur un projet complet. Lisez la situation, essayez de répondre à chaque question, puis lisez la réponse commentée. Les données sont **fictives**.

Document – La situation

L'école élémentaire des Glycines compte 6 classes et 150 élèves. Constat de l'infirmière scolaire : à la récréation du matin, la plupart des élèves mangent des biscuits ou des viennoiseries, et peu apportent un fruit. Pendant 8 semaines, de mars à mai, l'école organise le défi « Un fruit à la récré » : un maraîcher partenaire fournit des fruits de saison deux matins par semaine, une diététicienne anime une séance de dégustation dans chaque classe, et les familles reçoivent des idées de collations. L'objectif spécifique est : « À la fin du défi, au moins 40 % des élèves apportent un fruit pour la récréation du matin. » Une école voisine, de taille et de recrutement proches, accepte d'être observée aux mêmes dates sans participer au défi.

Étape 1 – Formuler trois questions évaluatives.

Réponse commentée – Étape 1

Efficacité : « La part des élèves qui apportent un fruit pour la récréation a-t-elle atteint 40 % à la fin du défi ? » Processus : « Les distributions et les séances de dégustation ont-elles eu lieu comme prévu, dans toutes les classes ? » Effets inattendus et durabilité : « Le défi a-t-il eu des effets non prévus (gaspillage, moqueries, implication des familles) et pourra-t-il continuer l'an prochain ? » Chaque question renvoie à une décision : reconduire, ajuster ou étendre.

Étape 2 – Construire le plan d'évaluation (indicateurs principaux).

Réponse commentée – Étape 2

Réalisation : distributions réalisées / prévues (16 prévues : 2 par semaine pendant 8 semaines) ; séances de dégustation réalisées (6 prévues). Participation : familles présentes à la réunion d'information. Résultat : part des élèves qui apportent un fruit, mesurée par **observation** de la récréation pendant deux matins avant le défi et deux matins deux semaines après, avec une grille, chez les mêmes élèves. Effets inattendus : part des fruits distribués jetés (observation des poubelles de la cour), question ouverte aux enseignants et aux élèves. Comparaison : même observation dans l'école voisine. Le choix de l'observation plutôt que d'un questionnaire évite la désirabilité sociale, difficile à contrôler chez des enfants.

Étape 3 – Analyser le processus. 15 distributions ont eu lieu sur 16 (un matin de grève) ; les 6 séances ont été réalisées ; 42 familles sur 138 sont venues à la réunion d'information.

Réponse commentée – Étape 3

Taux de réalisation des distributions : 15 / 16 × 100 = **93,8 %** ; séances : 6 / 6 = **100 %.** Participation des familles : 42 / 138 × 100 = **30,4 %** : c'est le point faible du processus. Le défi a été mis en œuvre presque

intégralement auprès des élèves, mais il a peu touché les familles, qui préparent pourtant les collations.

Étape 4 – Analyser le résultat principal. 120 élèves ont été observés aux deux temps : 18 apportaient un fruit avant et après ; 4 avant seulement ; 34 après seulement ; 64 ni avant ni après.

Réponse commentée – Étape 4

Avant : (18 + 4) / 120 = 22 / 120 = **18,3 %** ; après : (18 + 34) / 120 = 52 / 120 = **43,3 %** ; évolution **+ 25,0 points**. Taux d'atteinte : 43,3 / 40 × 100 = **108,3 %** : l'objectif est atteint. Part ayant progressé parmi ceux qui pouvaient progresser : 34 / (34 + 64) = 34 / 98 = **34,7 %** ; régression : 4 / 22 = **18,2 %**. Test de McNemar : b + c = 38, supérieur à 10 ; $\chi^2 = (|4 - 34| - 1)^2 / 38 = 29^2 / 38 = 841 / 38 =$ **22,1**, très supérieur à 3,84 : l'évolution est statistiquement significative.

Étape 5 – Utiliser le groupe de comparaison. Dans l'école voisine, 15 élèves sur 96 apportaient un fruit avant, 19 sur 96 après.

Réponse commentée – Étape 5

École voisine : 15 / 96 = **15,6 %** → 19 / 96 = **19,8 %**, soit **+ 4,2 points** (arrivée des fraises, effet de saison). Différence des évolutions : 25,0 − 4,2 = **20,8 points** : c'est l'estimation de l'effet propre du défi. Les deux écoles partaient d'un niveau proche (18,3 % et 15,6 %), ce qui renforce la comparaison. Limite : les écoles ne sont pas tirées au sort, et d'autres différences (équipe enseignante, cantine) peuvent jouer.

Étape 6 – Exploiter le qualitatif et repérer les effets inattendus. Environ 11 % des fruits distribués ont été retrouvés entamés dans les poubelles. Verbatims : « Les clémentines, c'est trop long à éplucher, on n'a pas le temps de jouer » (élève de CP) ; « Les enfants comparent leurs fruits, ça crée une émulation » (enseignante) ; « Ma fille m'a demandé d'acheter des kiwis, elle n'en mangeait jamais » (parent).

Réponse commentée – Étape 6

Effets positifs inattendus : **émulation** entre élèves, **demandes** des enfants à la maison (le défi touche les familles par les enfants). Effet négatif : un **gaspillage** d'environ 11 % des fruits, en partie lié au temps de préparation pour les plus jeunes. Ajustements : fruits faciles à manger ou préparés pour les CP (quartiers de pomme, bananes), petites portions. On vérifie aussi qu'aucun élève n'est moqué parce qu'il apporte un autre aliment.

Étape 7 – Calculer l'efficience. Fruits : 0,22 € par élève et par distribution ; diététicienne : 6 heures à 50 € ; affiches : 60 €.

Réponse commentée – Étape 7

Fruits : 15 × 150 × 0,22 = **495 €** ; diététicienne : 6 × 50 = **300 €** ; affiches **60 €** ; total **855 €**. Coût par élève : 855 / 150 = **5,70 €** ; coût par élève ayant adopté le fruit parmi les élèves observés : 855 / 34 = **25,15 €**. Le coût est modeste au regard du résultat ; il dépend surtout des fruits, qu'un partenariat durable avec le maraîcher ou un financement de la commune pourrait couvrir.

Étape 8 – Juger, décider et valoriser.

Réponse commentée – Étape 8

Jugement : le défi a été mis en œuvre comme prévu, l'objectif est dépassé (43,3 % pour 40 %) et l'évolution dépasse nettement celle de l'école voisine ; les points faibles sont la faible participation des familles à la réunion et le gaspillage chez les plus jeunes ; le maintien après l'arrêt des distributions n'est pas encore connu. Décision proposée : **reconduire et ajuster** (fruits adaptés aux CP, information des familles par les enfants et par un message illustré, observation de rappel en juin pour mesurer le maintien sans distribution).

Valorisation : restitution aux élèves sous forme d'un grand graphique dans le hall (« Plus de deux fois plus de fruits à la récré ! ») ; note d'une page à la mairie avec le coût par élève et la demande de financement des fruits ; article dans le bulletin de l'école ; compte rendu au conseil d'école ; fiche de capitalisation pour les autres écoles de la commune.

Ce que le jury attend sur l'évaluation et la valorisation

À l'épreuve E5 comme à l'oral, l'évaluation est le moment où le jury vérifie que vous savez **mesurer**, **interpréter** et **décider**. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes.

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Une évaluation prévue dès la conception	Un plan d'évaluation daté, avec un état initial mesuré	Un questionnaire improvisé à la fin, sans « avant »
Des indicateurs complets	Intitulé, calcul, valeur initiale, cible, source, moment, responsable	« Les participants seront satisfaits »
Des calculs justes et expliqués	Formules, effectifs, arrondis cohérents, unités	Des pourcentages sans dénominateur, des erreurs de points et de pourcentages
Une interprétation en quatre temps	Constater, comparer, expliquer, nuancer	Des chiffres posés sans commentaire
Des limites lucides	Biais identifiés, perdus de vue, absence de comparaison	« Aucune limite », ou au contraire des limites qui annulent tout
Des recommandations utiles	Constat, action, acteur, délai, indicateur	« Continuer le projet »
Une valorisation adaptée	Plusieurs supports, chacun pour un public	« J'ai fait une affiche »
Le respect de l'éthique	Anonymat, consentement, restitution aux participants	Résultats individuels exposés, photos sans accord

Astuce – Une phrase de jugement par objectif

Pour chaque objectif spécifique, terminez l'analyse par une phrase de jugement explicite : « L'objectif est atteint / partiellement atteint / non atteint, parce que… ; la principale limite est… ; nous recommandons… ». Le jury retrouve ainsi immédiatement votre conclusion.

Erreurs fréquentes – Évaluation et valorisation

- **Oublier la mesure initiale** : sans « avant », aucune évolution ne peut être montrée.
- **Confondre réalisation et résultat** : « 8 ateliers réalisés » ou « 150 livrets distribués » ne disent rien du changement chez le public.
- **Confondre points et pourcentage** : de 30 % à 45 %, c'est + 15 points, soit + 50 % en valeur relative.
- **Comparer des groupes différents** : 25 réponses avant et 14 après ne sont pas comparables ; analyser les réponses appariées.
- **Conclure à un effet démontré** à partir d'un simple avant / après sans groupe de comparaison.
- **Appliquer le test de McNemar avec moins de 10 changements** sans le signaler, ou croire que « significatif » veut dire « grâce à l'action ».
- **Calculer un taux d'atteinte pour une cible maximale** (coût, restes) au lieu de vérifier si le plafond est respecté.
- **Oublier les effets indésirables et l'équité** : une action peut réussir en moyenne tout en laissant de côté les plus éloignés.
- **Présenter des graphiques trompeurs** : axe tronqué, effectifs absents, secteurs en 3D.
- **Exposer des résultats individuels** ou des sous-groupes de moins de cinq personnes lors d'une restitution.

- **Formuler des recommandations vagues**, sans lien avec les résultats.

9.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Évaluer

- **Évaluer** = porter un jugement de valeur fondé sur des informations rigoureuses et des critères explicites, pour décider et rendre compte.
- **Types** : ex ante, en cours, ex post, à distance ; formative / sommative ; **processus** (a-t-on fait ce qui était prévu ?), **résultats** (objectifs spécifiques atteints ?), **impact** (objectif général, long terme) ; interne, externe, participative.
- **Critères** (OCDE, 2019) : pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact, durabilité ; **RE-AIM** : portée, efficacité, adoption, mise en œuvre, maintien.
- **Indicateur complet** : intitulé, calcul, valeur initiale, cible, source, moment, responsable ; types : ressources, activité, participation, satisfaction, résultat, impact.
- **Plans** : après seul < avant/après < avec comparaison < essai randomisé ; méthodes mixtes.
- **Calculs** : réalisation, participation (58/72 = 80,6 %), atteinte (75/60 = 125 %), progression (+ 50 points), gain normalisé ((7,17 − 4,75)/(10 − 4,75) = 0,46), coût par résultat (3 590,90/9 = 398,99 €).
- **Limites** : petit effectif, déclaratif, pas de comparaison, sélection, perdus de vue, court terme, effet Hawthorne ; interpréter en 4 temps : constater, comparer, expliquer, nuancer.

À retenir – Valoriser

- **Destinataires** : participants (restitution), structure et partenaires (bilan, COPIL), financeurs (compte rendu financier, Cerfa n° 15059), grand public, professionnels (poster, capitalisation), décideurs (note de synthèse).
- **Pérennisation** : relais formés, outils, intégration au projet de la structure, financements pluriannuels.
- **Transférabilité** : fonctions clés (grille ASTAIRE) ; **capitalisation** (portail CAPS).
- **Dossier** : plan d'évaluation, résultats interprétés, discussion des limites, bilan, perspectives, auto-évaluation.

À retenir – Compléments : analyses appariées, qualitatif, animation, équité, oral

- **Avant/après appariés** : tableau de transition (progression, régression, stables) ; % de progressants parmi ceux qui pouvaient progresser ; analyse des seules réponses appariées ; perdus de vue.
- **Qualitatif** : entretiens, groupe de bilan, changement le plus significatif ; codage thématique en 5 étapes ; convergence avec les chiffres.
- **Animation** : grille d'observation (8 critères) ; auto-évaluation (F14) ; capacité d'ajustement.
- **Équité** : indice de représentation = part dans les participants / part dans la population ; progression par groupe.
- **Environnement** : gaspillage par repas (kg / repas), produits durables, protéines végétales.
- **Oral** : une idée par diapositive, titres-messages, chiffres sourcés, 1 diapositive par minute ; connaître ses chiffres, justifier, reconnaître ses limites.

9.8 Entraînement

9.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Évaluer un projet, c'est :

a) porter un jugement de valeur fondé sur des informations rigoureuses **b)** seulement mesurer la satisfaction **c)** comparer ce qui est observé à ce qui était attendu **d)** aider à la décision

QCM 2 – L'évaluation de processus porte sur :

a) les activités réalisées **b)** la participation du public **c)** l'état de santé à 10 ans **d)** le respect du budget et du calendrier

QCM 3 – L'évaluation des résultats vérifie :

a) l'atteinte des objectifs spécifiques **b)** le nombre d'affiches imprimées **c)** l'évolution des connaissances ou des comportements **d)** la mortalité

QCM 4 – Une évaluation formative :

a) a lieu pendant l'action **b)** sert à l'améliorer **c)** a lieu uniquement à la fin **d)** est réservée aux évaluateurs externes

QCM 5 – L'efficience rapporte :

a) les résultats aux objectifs **b)** les résultats aux ressources utilisées **c)** le projet aux besoins **d)** les effets à la durée

QCM 6 – La pertinence d'un projet désigne :

a) sa réponse aux besoins identifiés **b)** son coût **c)** l'adéquation aux priorités **d)** sa durée

QCM 7 – Un indicateur complet comprend :

a) une valeur initiale **b)** une valeur cible **c)** une source de recueil **d)** le nom des participants

QCM 8 – 58 présences pour 6 ateliers de 12 inscrits donnent un taux de participation de :

a) 58 % **b)** 80,6 % **c)** 96,7 % **d)** 48,3 %

QCM 9 – Un objectif fixé à 60 % et un résultat de 75 % donnent un taux d'atteinte de :

a) 15 % **b)** 80 % **c)** 125 % **d)** 135 %

QCM 10 – Le gain normalisé d'un score passant de 4 à 7 sur 10 vaut :

a) 0,3 **b)** 0,5 **c)** 0,75 **d)** 3

QCM 11 – Dans le modèle RE-AIM, R signifie :

a) résultats **b)** portée (reach) **c)** ressources **d)** restitution

QCM 12 – Parmi ces limites, lesquelles concernent une évaluation avant/après sans groupe de comparaison ?

a) on ne peut pas attribuer avec certitude le changement à l'action **b)** les données déclaratives peuvent être biaisées **c)** le petit effectif rend les pourcentages instables **d)** aucune

QCM 13 – Le compte rendu financier d'une subvention associative :

a) utilise le formulaire Cerfa n° 15059 **b)** est facultatif **c)** explique l'usage de la subvention **d)** est remis au financeur

QCM 14 – La transférabilité d'une action :

a) est sa capacité à produire des effets similaires ailleurs **b)** dépend de fonctions clés **c)** peut s'analyser avec la grille ASTAIRE **d)** est garantie si l'action a réussi une fois

QCM 15 – Un poster professionnel :

a) contient surtout du texte **b)** présente objectifs, méthode, résultats, limites **c)** doit être lisible à distance **d)** comporte les logos des partenaires et financeurs

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, c, d. 2. **a, b, d**. 3. **a, c**. 4. **a, b**. 5. **b**. 6. **a, c**. 7. **a, b, c**. 8. **b** (58 / 72 × 100). 9. **c** (75 / 60 × 100). 10. **b** ((7 − 4) / (10 −

4. = 3 / 6). 11. **b**. 12. **a, b, c**. 13. **a, c, d**. 14. **a, b, c**. 15. **b, c, d**.

QCM 16 – Dans un tableau de transition avant/après, les cases utiles au test de McNemar sont :

a) les personnes stables **b)** les personnes ayant changé dans un sens ou dans l'autre **c)** le total général **d)** aucune

QCM 17 – Un indice de représentation de 0,5 pour le public prioritaire signifie :

a) qu'il est sous-représenté de moitié parmi les participants **b)** qu'il est sur-représenté **c)** qu'il est représenté proportionnellement **d)** que la moitié des participants sont prioritaires

QCM 18 – La technique du « changement le plus significatif » :

a) recueille des récits de changement **b)** est une méthode qualitative **c)** remplace tous les indicateurs chiffrés **d)** a été proposée par Davies et Dart

QCM 19 – 260 kg de restes pour 2 000 repas représentent :

a) 130 g par repas **b)** 13 g par repas **c)** 0,13 kg par repas **d)** 1,3 kg par repas

QCM 20 – Un bon diaporama de présentation :

a) contient de longs paragraphes **b)** a des titres qui énoncent le message **c)** cite les sources des chiffres **d)** comporte environ une diapositive par minute

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM complémentaires

16. b. 17. **a**. 18. **a, b, d**. 19. **a, c** (260 / 2 000 = 0,13 kg). 20. **b, c, d**.

9.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : la chaîne des effets

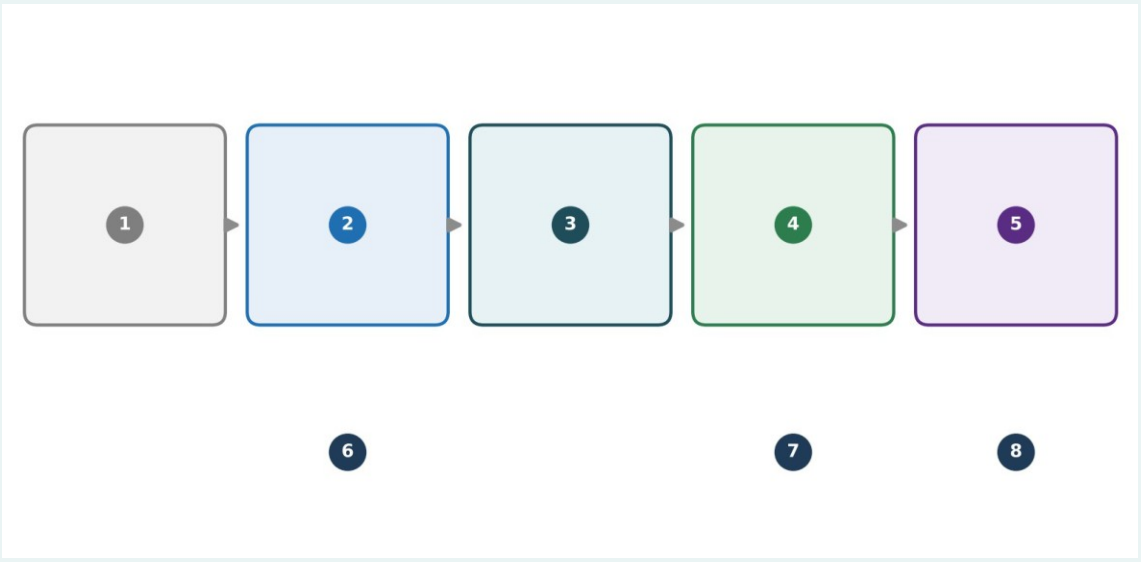


Figure 9.6 – Schéma à légender

Légendez les maillons 1 à 5 et les niveaux d'évaluation 6 à 8, puis classez les indicateurs : a) 8 ateliers

réalisés ; b) 900 € dépensés ; c) 70 % des participants savent lire le Nutri-Score ; d) baisse de la prévalence du diabète ; e) 92 % de satisfaits.

Corrigé

1. Ressources. 2. Activités. 3. Réalisations. 4. Résultats. 5. Impact. 6. Évaluation de processus. 7. Évaluation des résultats. 8. Évaluation d'impact. Classement : a) réalisation (processus) ; b) ressources (processus) ; c) résultat ; d) impact ; e) satisfaction (processus : perception de la mise en œuvre).

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : RE-AIM

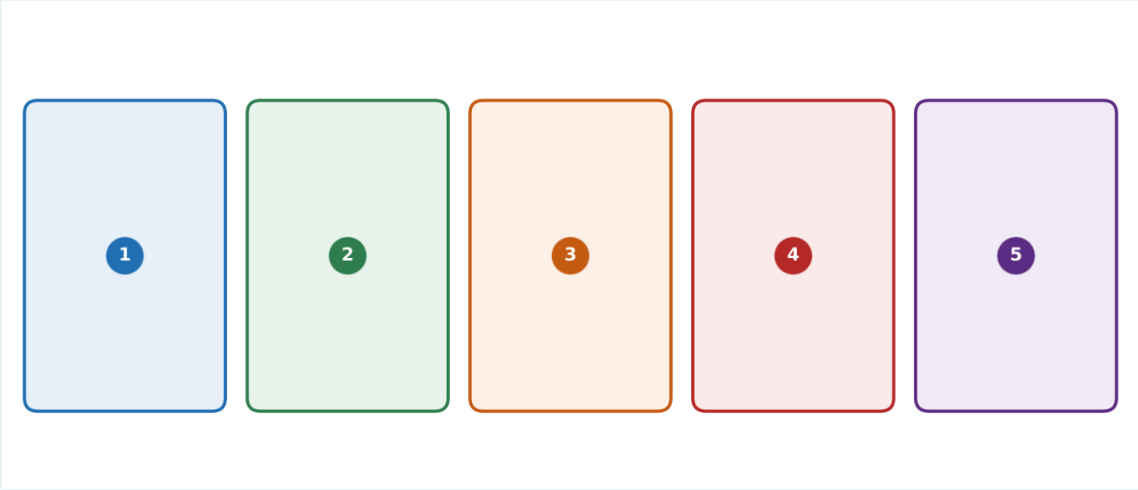


Figure 9.7 – Schéma à légender

Nommez les dimensions 1 à 5 et donnez pour chacune un indicateur pour un programme d'ateliers en EHPAD.

Corrigé

1. Portée : part des résidents ayant participé au moins une fois. 2. **Efficacité** : évolution des apports (fiches de consommation), du poids, de la satisfaction. 3. **Adoption** : nombre d'unités de l'EHPAD qui organisent les ateliers. 4. **Mise en œuvre** : séances réalisées / prévues, fidélité au conducteur, coût. 5. **Maintien** : ateliers poursuivis 6 mois après, maintien du poids.

À vous de jouer – Exercice 3 – Construire un plan d'évaluation

Objectif spécifique : « D'ici juin, au moins 70 % des élèves de 6e prennent un petit-déjeuner au moins 4 jours sur 5 (contre 52 % en septembre). » Construisez l'indicateur complet et deux indicateurs de processus.

Corrigé

Résultat : part des élèves de 6e déclarant un petit-déjeuner au moins 4 jours sur 5 ; calcul : élèves concernés / répondants × 100 ; initiale 52 % (septembre) ; cible ≥ 70 % ; source : questionnaire anonyme en classe ; moments : septembre et juin ; responsable : infirmière et diététicien. **Processus** : nombre de séances réalisées / prévues ; taux de participation des élèves aux petits-déjeuners éducatifs (présences / effectif).

À vous de jouer – Exercice 4 – Calculer et interpréter des résultats

Un cycle de 8 ateliers pour 15 seniors : présences par séance 14, 13, 13, 12, 11, 12, 10, 12. Score de

connaissances moyen 5,2/10 avant, 7,6/10 après. 9 seniors sur 15 déclaraient manger un produit laitier à chaque repas avant, 13 après. Calculez les indicateurs et rédigez l'interprétation en 4 temps (objectifs : participation ≥ 75 % ; score ≥ 7 ; produits laitiers ≥ 80 %).

Corrigé

Présences : 14 + 13 + 13 + 12 + 11 + 12 + 10 + 12 = **97** ; possibles : 8 × 15 = 120 ; taux : 97 / 120 × 100 = **80,8 %** (atteint). Score : progression + 2,4 points ; gain normalisé : 2,4 / (10 − 5,2) = 2,4 / 4,8 = **0,50** ; atteinte : 7,6 / 7 × 100 = **108,6 %**. Produits laitiers : 9 / 15 = **60 %** → 13 / 15 = **86,7 %** ; + 26,7 points ; atteinte : 86,7 / 80 × 100 = **108,3 %**. Interprétation : **constater** (la part des seniors consommant un produit laitier à chaque repas passe de 9 à 13 sur 15) ; **comparer** (objectif de 80 % dépassé) ; **expliquer** (dégustations, recettes simples, coût faible) ; **nuancer** (déclaratif, 15 personnes, baisse de participation en fin de cycle : 10 présents à la 7e séance, à analyser).

À vous de jouer – Exercice 5 – Efficience

Deux projets : A coûte 4 200 € et 28 participants sur 40 atteignent l'objectif ; B coûte 2 600 € et 12 participants sur 20 l'atteignent. Comparez l'efficacité et l'efficience.

Corrigé

Efficacité : A 28 / 40 = **70 %** ; B 12 / 20 = **60 %** → A plus efficace. Efficience (coût par personne ayant atteint l'objectif) : A 4 200 / 28 = **150 €** ; B 2 600 / 12 = **216,67 €** → A aussi plus efficient. Coût par participant : A 4 200 / 40 = 105 € ; B 2 600 / 20 = 130 €. Nuance : les publics et les objectifs doivent être comparables pour que la comparaison ait un sens.

À vous de jouer – Exercice 6 – Choisir des outils d'évaluation adaptés

Proposez des outils d'évaluation pour : a) des enfants de 5 ans ; b) des adultes apprenant le français ; c) des adolescents ; d) des personnes âgées en EHPAD avec troubles cognitifs.

Corrigé

a) Smileys à colorier, gommettes sur une affiche, dessin « ce que j'ai aimé goûter », observation des dégustations. b) Échelles imagées, questions orales avec médiation, grille d'observation des compétences (choisir un produit). c) Questionnaire court anonyme sur smartphone **et** papier, vote à main levée, quiz interactif. d) Observation des consommations (fiches), avis des soignants et des familles, expression non verbale (plaisir), questions très simples.

À vous de jouer – Exercice 7 – Identifier les limites

Un rapport conclut : « Grâce à nos ateliers, les 18 familles mangent désormais équilibré et le surpoids des enfants va diminuer. » Relevez les erreurs et réécrivez.

Corrigé

Erreurs : attribution causale certaine sans comparaison ; généralisation (« mangent équilibré ») sans indicateur précis ; prédiction d'impact non démontrée ; absence de chiffres et de limites. Réécriture : « Parmi les 18 familles participantes, la part déclarant consommer des légumes chaque jour est passée de 6 à 13 (33 % à 72 %). Ces données déclaratives, recueillies sans groupe de comparaison et à court terme, sont

encourageantes ; un suivi à 3 mois permettra d'apprécier le maintien de ces changements. »

À vous de jouer – Exercice 8 – Analyse de l'évolution de la participation

Présences par séance (12 inscrits) : 12, 11, 9, 8, 7, 7. Calculez le taux par séance et le taux global, représentez-le et proposez des explications et des mesures.

Corrigé

Taux : 100 % ; 91,7 % ; 75 % ; 66,7 % ; 58,3 % ; 58,3 %. Global : (12 + 11 + 9 + 8 + 7 + 7) / 72 = 54 / 72 × 100 = **75 %**. Courbe (évolution) avec la cible de 80 % en pointillés. Explications possibles : horaires, thèmes moins attractifs, contraintes familiales, malaise dans le groupe. Mesures : entretien avec les absents, rappel la veille, choix des thèmes par les participants, garde d'enfants.

À vous de jouer – Exercice 9 – Rédiger une note de synthèse pour des élus

Rédigez en 10 lignes la note de synthèse du projet des Tilleuls pour le comité du CLS.

Corrigé

« **Projet « Bien manger, petit budget, grand plaisir » – centre social des Tilleuls (mars-mai 2028)**. Public : 12 familles du QPV (75 % monoparentales). Actions : 6 ateliers culinaires, visite du marché, livret de 12 recettes, partenariat avec l'épicerie solidaire. Participation : 80,6 %. Résultats : familles consommant des légumes secs ≥ 2 fois/semaine : 25 % → 75 % ; connaissances : 4,75 → 7,17/10 ; satisfaction : 92 %. Coût : 3 590,90 € (299 € par famille), dont 42,7 % ARS. Limites : 12 familles volontaires, données déclaratives. **Recommandations** : reconduire le cycle avec les relais formés (2 cycles par an), étendre au quartier voisin, étudier une navette vers le marché. »

À vous de jouer – Exercice 10 – Plan d'un poster

Proposez le plan détaillé d'un poster présentant un projet d'éducation au goût en école maternelle.

Corrigé

Titre : « Goûter, c'est grandir ! Éducation au goût dans 3 écoles maternelles ». Auteurs, structure. Contexte : néophobie de 2 à 6 ans, 2 chiffres. Objectifs : 2 objectifs spécifiques. Méthode : 6 séances sensorielles, 180 enfants, partenariat avec la cuisine centrale, évaluation (fiches de dégustation, pesée des restes). Résultats : graphique de la part d'enfants acceptant de goûter (avant/après) ; restes de légumes en g par enfant. Discussion : limites, effets sur les familles. Perspectives. Logos, contact, photo de mains d'enfants (autorisations).

9.8.3 Questions de réflexion

À vous de jouer – Question 1

Pourquoi un projet de stage ne peut-il pas démontrer un impact sur la santé ?

Corrigé

Parce que la durée est trop courte, l'effectif trop petit, les déterminants de la santé multiples et l'absence de groupe de comparaison empêche d'attribuer un changement à l'action ; on évalue donc le processus et les résultats intermédiaires (connaissances, comportements), et on relie l'action à des données probantes pour argumenter un impact **plausible**.

À vous de jouer – Question 2

Faut-il présenter les résultats négatifs ?

Corrigé

Oui : ils sont utiles pour améliorer l'action, crédibilisent l'évaluation, respectent l'honnêteté due aux financeurs et aux participants, et contribuent à la connaissance collective. Ils doivent être analysés (causes) et accompagnés de recommandations.

À vous de jouer – Question 3

Satisfaction et efficacité, est-ce la même chose ?

Corrigé

Non : des participants très satisfaits peuvent ne rien changer à leurs pratiques, et inversement. La satisfaction renseigne sur l'acceptabilité et la qualité perçue (processus) ; l'efficacité se mesure par l'atteinte des objectifs spécifiques (résultats).

9.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – Évaluer un programme « Bien vieillir à table »

Un CCAS a mené un programme de 10 ateliers pour 16 seniors isolés (objectifs : rompre l'isolement au moment des repas ; améliorer la consommation de protéines ; prévenir la dénutrition). Données : présences 14, 15, 13, 12, 14, 13, 11, 12, 13, 12 ; avant/après : seniors déjeunant seuls 7 jours sur 7 : 11 → 6 ; consommant une source de protéines au déjeuner chaque jour : 7 → 12 ; satisfaction : 15 sur 16 ; coût : 5 120 €.

1. Construisez le tableau de bord (processus et résultats) avec les calculs.
2. Évaluez le programme selon les 6 critères de l'OCDE.
3. Discutez les limites et proposez des améliorations de la méthode.
4. Proposez un plan de valorisation (destinataires, supports).
5. Proposez des perspectives de pérennisation.

Corrigé

1. Présences : 14 + 15 + 13 + 12 + 14 + 13 + 11 + 12 + 13 + 12 = **129** ; possibles 10 × 16 = 160 ; taux : 129 / 160 × 100 = **80,6 %**. Déjeunent seuls tous les jours : 11 / 16 = **68,8 %** → 6 / 16 = **37,5 %** (− 31,3 points ; 5 personnes en moins). Protéines quotidiennes : 7 / 16 = **43,8 %** → 12 / 16 = **75 %** (+ 31,3 points). Satisfaction : 15 / 16 = **93,8 %**. Coût par participant : 5 120 / 16 = **320 €** ; coût par séance : 5 120 / 10 = **512 €**.

2. Pertinence : répond à l'isolement et au risque de dénutrition identifiés. **Cohérence** : s'inscrit dans les priorités de la conférence des financeurs et du CLS. **Efficacité** : résultats favorables sur les deux

comportements. **Efficience** : 320 € par senior pour 10 séances, raisonnable. **Impact** : liens créés (repas partagés spontanés ?) à documenter ; prévention de la dénutrition non mesurée (pas de pesée). **Durabilité** : à construire (relais, repas partagés autonomes).

3. Limites : 16 personnes, déclaratif, pas de mesure du poids ni de l'appétit (MNA), pas de suivi à distance. Améliorations : pesée et outil de dépistage validé avec l'accord des personnes et en lien avec le médecin, entretien à 3 mois, recueil des effets sur le moral.
4. Seniors : repas festif de clôture et livret ; CCAS et partenaires : rapport et COPIL ; financeur : compte rendu financier et bilan ; grand public : article dans le bulletin municipal ; professionnels : fiche de capitalisation ; élus : note d'une page.
5. Repas partagés hebdomadaires animés par des bénévoles formés, intégration au programme annuel du CCAS, nouvelle demande à la conférence des financeurs, partenariat avec un restaurant scolaire (repas intergénérationnels).

9.8.5 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Quelle différence entre évaluation de processus et de résultats ? »

Corrigé

Le processus vérifie si l'action a été réalisée comme prévu (activités, participation, budget) ; les résultats vérifient si les objectifs spécifiques sont atteints (changements de connaissances, de comportements).

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Vos résultats prouvent-ils l'efficacité de votre projet ? »

Corrigé

Ils montrent une évolution favorable chez les participants, mais sans groupe de comparaison, avec 12 familles et des données déclaratives, je ne peux pas l'attribuer avec certitude à l'action ; je parle donc de résultats encourageants et j'explique comment je renforcerais l'évaluation.

Mise en situation – MSE 3

Votre tutrice vous demande de « ne garder que les bons résultats » pour le financeur.

Corrigé

J'explique qu'un bilan honnête est plus crédible et qu'il est dû au financeur ; je propose de présenter les difficultés avec leur analyse et les ajustements, ce qui valorise la capacité d'adaptation de la structure.

Mise en situation – MSE 4

Le jury : « Qu'est-ce qu'un indicateur ? Donnez-en un de votre projet. »

Corrigé

Une variable observable et mesurable qui renseigne sur l'atteinte d'un objectif ; par exemple, la part des familles consommant des légumes secs au moins deux fois par semaine, valeur initiale 25 %, cible 60 %, mesurée par questionnaire au 1er et au 6e atelier.

Mise en situation – MSE 5

Le jury : « Comment avez-vous restitué les résultats aux familles ? »

Corrigé

Lors du temps fort festif, avec des résultats en images (« 9 familles sur 12 cuisinent les légumes secs ! »), la remise du livret et un échange sur la suite qu'elles souhaitaient.

Mise en situation – MSE 6

Le jury : « Qu'est-ce que l'efficience ? »

Corrigé

Le rapport entre les résultats obtenus et les ressources mobilisées ; par exemple, le coût par famille ayant atteint l'objectif : 3 590,90 € / 9 = 399 €.

Mise en situation – MSE 7

La moitié des participants n'ont pas rempli le questionnaire final.

Corrigé

Je le signale (perdus de vue), j'analyse uniquement les questionnaires appariés en précisant n, je complète par un appel ou un entretien court, et j'en tire une leçon (questionnaire au début de la dernière séance).

Mise en situation – MSE 8

Le jury : « Votre projet va-t-il continuer ? »

Corrigé

Oui : la référente et deux mamans relais ont été formées et animeront un nouveau cycle avec mes conducteurs ; une demande de financement a été déposée dans le cadre du CLS ; un centre social voisin a demandé les outils.

Mise en situation – MSE 9

Le jury : « Qu'avez-vous appris en évaluant votre projet ? »

Corrigé

L'importance de mesurer l'état initial dès le premier atelier, de varier les outils selon le public, de chercher les effets inattendus et de présenter honnêtement les limites ; et que la satisfaction ne suffit pas.

Mise en situation – MSE 10

Un financeur demande l'impact du projet sur l'obésité des enfants.

Corrigé

J'explique que la durée et l'effectif ne permettent pas de le mesurer ; je présente les résultats intermédiaires (comportements des familles) et les données probantes reliant ces comportements à la santé, et je propose un suivi à plus long terme en partenariat avec la santé scolaire (données agrégées).

Mise en situation – MSE 11

Le jury : « Pourquoi avoir fait un poster ? »

Corrigé

Pour partager l'expérience avec d'autres professionnels (journée régionale), favoriser la capitalisation et la transférabilité, et valoriser le travail des familles et des partenaires.

Mise en situation – MSE 12

Le jury : « Si c'était à refaire, que changeriez-vous ? »

Corrigé

Je mesurerais l'état initial pendant le diagnostic, j'ajouterais un groupe de comparaison (familles de l'épicerie non participantes), un appel à 3 mois, et je prévoirais plus de temps de préparation ; je garderais la participation des familles au choix des recettes.

9.8.6 Exercices complémentaires

À vous de jouer – Exercice 11 – Schéma à légender : le poster

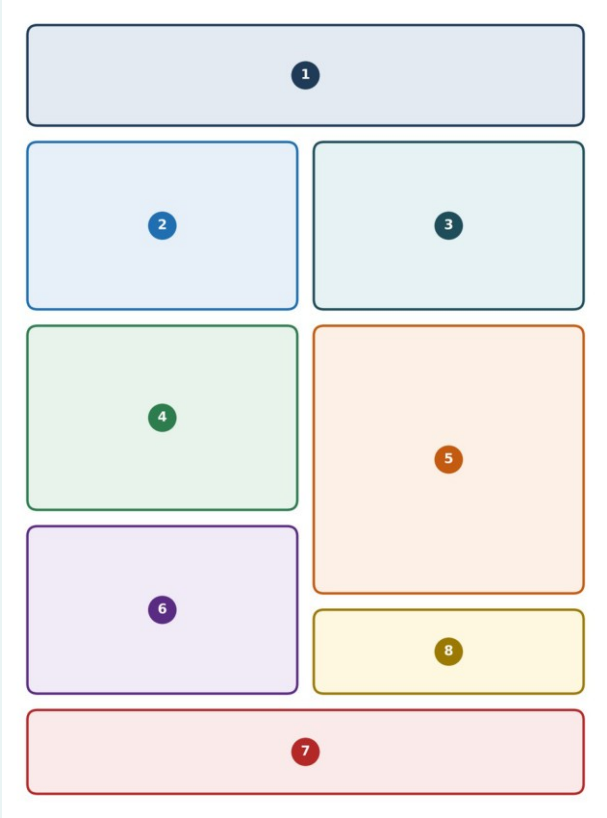


Figure 9.9 – Schéma à légender

Nommez les zones 1 à 8 d'un poster professionnel et indiquez, pour le projet des Tilleuls, ce que vous placeriez dans les zones 2 et 5.

Corrigé

1. Titre, auteurs, structure, logos. 2. Contexte. 3. Objectifs. 4. Méthode. 5. Résultats. 6. Discussion. 7. Perspectives, contact, remerciements. 8. Photo ou schéma. Zone 2 : « Taux de pauvreté 41 % (15 % dans la commune) ; 14 % d'enfants en surpoids en grande section (9 % dans le département) ». Zone 5 : graphique avant/après (légumes secs 25 % → 75 % ; score 4,75 → 7,17/10) et chiffre-clé « 9 familles sur 12 ».

À vous de jouer – Exercice 12 – Tableau de transition

Indicateur « eau au goûter » chez 20 familles : 5 proposaient de l'eau avant et après ; 2 avant mais plus après ; 8 sont passées à l'eau ; 5 jamais. Construisez le tableau, calculez les pourcentages avant et après et la part de progressants parmi ceux qui pouvaient progresser.

Corrigé

Tableau : avant oui : 5 (oui après) + 2 (non après) = 7 ; avant non : 8 (oui après) + 5 (non après) = 13 ; après oui : 5 + 8 = 13 ; total 20. Avant : 7 / 20 = **35 %** ; après : 13 / 20 = **65 %**. Progressants : 8 / 13 = **61,5 %** ; régressants : 2 / 7 = **28,6 %** des familles qui proposaient de l'eau (à explorer : pourquoi ont-elles arrêté ?).

À vous de jouer – Exercice 13 – Codage de réponses ouvertes

Réponses de 10 participants à « Qu'est-ce qui vous a le plus aidé ? » : « cuisiner ensemble » ; « les recettes pas chères » ; « l'ambiance et cuisiner ensemble » ; « savoir le prix par portion » ; « les recettes, pas chères » ; « goûter des choses nouvelles » ; « l'ambiance » ; « les recettes avec des photos » ; « cuisiner avec d'autres

mamans » ; « le prix par portion et les recettes ». Codez en thèmes et comptez.

Corrigé

Thèmes : **convivialité / cuisiner ensemble** : réponses 1, 3, 7, 9 = **4** (40 %) ; **recettes économiques** : 2, 5, 10 = **3** (30 %) ; **prix par portion** : 4, 10 = **2** (20 %) ; **recettes accessibles (photos)** : 8 = **1** (10 %) ; **découverte** : 6 = **1** (10 %). Total supérieur à 10 car la réponse 10 contient deux thèmes. La convivialité est le premier facteur cité : à préserver dans les cycles suivants.

À vous de jouer – Exercice 14 – Indicateurs d'équité

Un programme d'ateliers a réuni 60 participants, dont 9 bénéficiaires de minima sociaux, alors qu'ils représentent 21 % de la population cible. Calculez l'indice de représentation et proposez trois actions correctrices.

Corrigé

Part des bénéficiaires : 9 / 60 = **15 %** ; indice : 15 / 21 = **0,71** : sous-représentation. Actions : orientation par les travailleurs sociaux et l'épicerie solidaire ; ateliers délocalisés dans le quartier, gratuits, avec garde d'enfants ; inscriptions non numériques et relais pairs.

À vous de jouer – Exercice 15 – Gaspillage par repas

Avant : 186 kg de restes pour 1 500 repas ; après : 152 kg pour 1 600 repas. Calculez le gaspillage par repas avant et après et la réduction ; expliquez pourquoi on ne compare pas les kilos bruts.

Corrigé

Avant : 186 / 1 500 = **0,124 kg** (124 g) ; après : 152 / 1 600 = **0,095 kg** (95 g). Réduction : 124 − 95 = **29 g**, soit 29 / 124 × 100 = **23,4 %**. Les kilos bruts (186 → 152, − 18,3 %) sous-estiment la réduction car le nombre de repas a augmenté ; on rapporte au nombre de repas.

À vous de jouer – Exercice 16 – Grille d'observation

Une séance obtient : consignes 3, participation 2, climat 4, imprévus 3, hygiène 4, faire dire 1, conducteur 2, objectif 3. Calculez le total sur 32 et le pourcentage ; identifiez deux axes d'amélioration et proposez une action pour chacun.

Corrigé

Total : 3 + 2 + 4 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 = **22 / 32**, soit **68,8 %**. Axes : **faire dire** (1) : prévoir 10 minutes de reformulation par binômes en fin de séance ; **conducteur** (2) et **participation** (2) : alléger le conducteur (moins d'étapes), tour de parole et rôles attribués.

9.9 Glossaire

Terme	Définition
Capitalisation	Transformation d'une expérience en connaissance partageable

Terme	Définition
Cohérence	Articulation interne (objectifs, actions, moyens) et externe (autres actions, politiques)
Compte rendu financier	Document justifiant l'usage d'une subvention (Cerfa n° 15059)
Durabilité	Maintien des effets et de l'action dans le temps
Efficacité	Atteinte des objectifs
Efficience	Résultats rapportés aux ressources
Évaluation	Jugement de valeur fondé sur des informations rigoureuses et des critères explicites
Évaluation de processus	Évaluation de la mise en œuvre (activités, participation, moyens)
Évaluation des résultats	Vérification de l'atteinte des objectifs spécifiques
Évaluation d'impact	Évaluation des effets à long terme (objectif général)
Évaluation formative / sommative	Pour améliorer pendant l'action / pour juger à la fin
Gain normalisé	(après − avant) / (maximum − avant)
Impact	Effets larges, à long terme, attendus ou non
Indicateur	Variable observable et mesurable renseignant sur un objectif
Pérennisation	Maintien de l'action après le financement initial
Pertinence	Adéquation du projet aux besoins et aux priorités
RE-AIM	Portée, efficacité, adoption, mise en œuvre, maintien
Taux d'atteinte	Valeur obtenue / valeur cible × 100
Transférabilité	Capacité d'une action à produire des effets similaires ailleurs
Valorisation	Faire connaître, restituer, rendre compte, capitaliser
Changement le plus significatif	Méthode qualitative de recueil et de sélection de récits de changement (Davies et Dart)
Codage thématique	Attribution de thèmes aux réponses ouvertes pour les analyser
Indice de représentation	Part d'un groupe parmi les participants / part dans la population
Perdus de vue	Participants sans mesure finale
Régression vers la moyenne	Rapprochement spontané des valeurs extrêmes de la moyenne lors d'une seconde mesure
Réponses appariées	Réponses avant et après d'une même personne, reliées par un code
Tableau de transition	Tableau croisant la situation avant et après pour une variable binaire

9.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Définitions, types	[1] Ridde et Dagenais ; [2] INPES guide d'autoévaluation
Critères	[3] OCDE 2019
Modèles	[4] Glasgow et coll. (RE-AIM) ; [5] Pawson et Tilley
Outils, catégorisation	[6] Promotion Santé Suisse
Données probantes, capitalisation	[7] Santé publique France ; [8] portail CAPS
Transférabilité	[9] Cambon et coll. (ASTAIRE)
Statistiques	[10] Hake ; [11] Cohen

Notion	Références
Bilan financier	[12] Cerfa n° 15059

9.12 Bibliographie numérotée

1. Ridde V., Dagenais C. (dir.). *Évaluation des interventions de santé mondiale : méthodes avancées*. Québec, Éditions science et bien commun, 2019 ; et *Approches et pratiques en évaluation de programmes*. Presses de l'Université de Montréal, 3e éd., 2020.

2. INPES. *Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion de la santé ? Guide d'autoévaluation*. 2009.

3. OCDE, Comité d'aide au développement. *Better Criteria for Better Evaluation: Revised Evaluation Criteria Definitions and Principles for Use*. 2019.

4. Glasgow R. E., Vogt T. M., Boles S. M. « Evaluating the public health impact of health promotion interventions: the RE-AIM framework ». *American Journal of Public Health*, 1999, 89 (9), p. 1322-1327.

5. Pawson R., Tilley N. *Realistic Evaluation*. Londres, Sage, 1997.

6. Promotion Santé Suisse. *Outil de catégorisation des résultats*. Adaptation française diffusée par Santé publique France.

7. Santé publique France. *Répertoire des interventions efficaces ou prometteuses en prévention et promotion de la santé*.

8. Portail CAPS – Capitalisation des expériences en promotion de la santé, *capitalisationsante.fr*.

9. Cambon L., Minary L., Ridde V., Alla F. « Transferability of interventions in health education: a review ». *BMC Public Health*, 2012, 12, 497 ; et outil ASTAIRE, 2013.

10. Hake R. R. « Interactive-engagement versus traditional methods ». *American Journal of Physics*, 1998, 66 (1), p. 64-74.

11. Cohen J. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 2e éd., Lawrence Erlbaum, 1988.

12. Formulaire Cerfa n° 15059 « Compte rendu financier de subvention », *service-public.fr*.

13. Davies R., Dart J. *The « Most Significant Change » (MSC) Technique: A Guide to Its Use*. 2005.

14. Barnett A. G., van der Pols J. C., Dobson A. J. « Regression to the mean: what it is and how to deal with it ». *International Journal of Epidemiology*, 2005, 34 (1), p. 215-220.

15. Paillé P., Mucchielli A. *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*. Paris, Armand Colin, 5e éd., 2021.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 9.2.2)

16. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE

CHAPITRE

09

Démarche de projet (3) : évaluation et valorisation

Démarche de projet (3) | Évaluer | Interpréter | Valoriser | Pérenniser

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

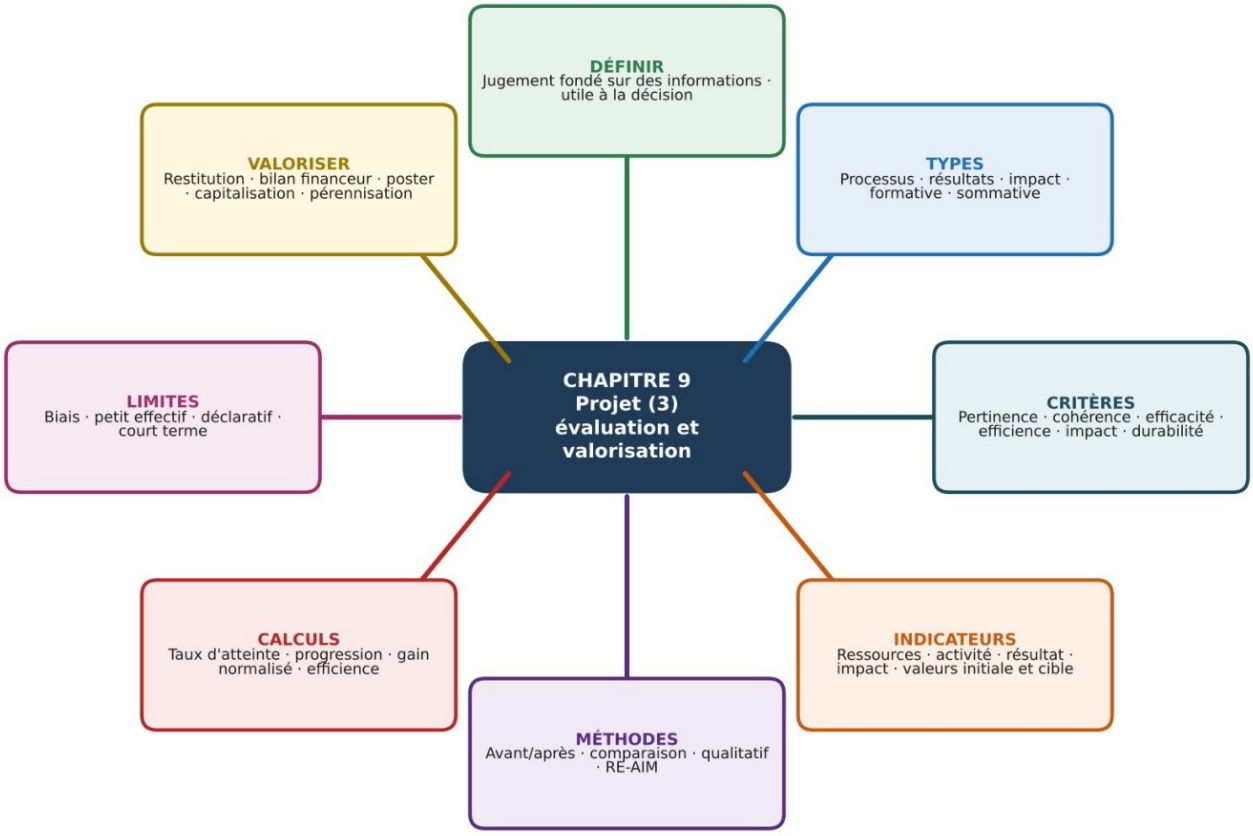
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 9 99
1. Les définitions à savoir 99
2. Les formules 99
3. Interpréter en 4 temps 100
4. Les limites classiques 100
5. Valoriser selon le destinataire 100
6. Les pièges 100
7. Auto-test 100
8. Flashcards 100
Compléments du chapitre enrichi 101

Fiches-outils du chapitre 9 101
O9.1 – Plan d'évaluation 101
O9.2 – Questionnaire de satisfaction accessible 101
O9.3 – Grille d'observation des compétences 102
O9.4 – Analyse avant / après 102
O9.5 – Grille des 6 critères 102
O9.6 – Plan de valorisation 102

Fiche de révision du chapitre 9

Démarche de projet (3) : évaluation et valorisation



Carte mentale du chapitre 9

1. Les définitions à savoir

Notion	Définition
Évaluation	Jugement de valeur fondé sur des informations rigoureuses et des critères, pour décider et rendre compte
Processus / résultats / impact	Mise en œuvre / objectifs spécifiques / long terme
Formative / sommative	Améliorer pendant / juger à la fin
Indicateur complet	Intitulé, calcul, valeur initiale, cible, source, moment, responsable
Critères (OCDE, 2019)	Pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact, durabilité
RE-AIM	Portée, efficacité, adoption, mise en œuvre, maintien
Valorisation	Restituer, rendre compte, faire connaître, capitaliser

2. Les formules

Calcul	Formule et exemple
Taux de réalisation	réalisé / prévu : 6 / 6 = 100 %

Calcul	Formule et exemple
Taux de participation	présences / (séances × inscrits) : 58 / 72 = 80,6 %
Taux d'atteinte	obtenu / cible : 75 / 60 = 125 %
Progression	après − avant : 75 − 25 = + 50 points
Gain normalisé	(après − avant) / (max − avant) : 2,42 / 5,25 = 0,46
Coût par résultat	coût / personnes ayant atteint l'objectif : 3 590,90 / 9 = 398,99 €
Différence des différences	évolution groupe action − évolution groupe comparaison

3. Interpréter en 4 temps

Constater → comparer à l'objectif → expliquer → nuancer (limites).

4. Les limites classiques

Petit effectif · déclaratif · pas de groupe de comparaison · sélection · perdus de vue · court terme · effet Hawthorne · apprentissage du questionnaire.

5. Valoriser selon le destinataire

Participants (temps fort, livret) · structure (rapport, COPIL) · financeur (bilan + Cerfa n° 15059) · grand public (article) · professionnels (poster, capitalisation CAPS) · décideurs (note d'une page).

6. Les pièges

Attention

- Conclure à un impact sur la santé à partir d'un projet de 3 mois.
- Présenter des résultats sans état initial ni objectif.
- Confondre satisfaction et efficacité.
- Cacher les difficultés et les résultats négatifs.
- Oublier de préparer l'évaluation avant l'action.

7. Auto-test

1. Les 3 niveaux d'évaluation ? 2. Les 6 critères ? 3. Que signifie RE-AIM ? 4. Formule du gain normalisé ? 5. Taux d'atteinte de 75 % pour une cible de 60 % ? 6. Cerfa du compte rendu financier ? 7. Grille de transférabilité ? 8. Les 4 temps de l'interprétation ? 9. Test pour un score apparié ? 10. Évaluation réaliste ? *Réponses : 1. Processus, résultats, impact – 2. Pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact, durabilité – 3. Portée, efficacité, adoption, mise en œuvre, maintien – 4. (après − avant)/(max − avant) – 5. 125 % – 6. 15059 – 7. ASTAIRE – 8. Constater, comparer, expliquer, nuancer – 9. Test t apparié – 10. Qu'est-ce qui marche, pour qui, dans quel contexte, pourquoi (Pawson et Tilley).*

8. Flashcards

Recto : Efficience ?	Verso : Résultats / ressources
Recto : Évaluation ex ante ?	Verso : Avant l'action : pertinence, faisabilité
Recto : Perdus de vue ?	Verso : Participants sans mesure finale : préciser n apparié
Recto : Effet Matthieu ?	Verso : L'action profite surtout aux plus favorisés
Recto : Pérennisation ?	Verso : Relais formés, outils, intégration, financements pluriannuels

Recto : Efficience ?	Verso : Résultats / ressources
Recto : Poster ?	Verso : 70 % images, 30 % texte ; lisible à 1,5 m

Compléments du chapitre enrichi

Notion	À retenir
Appariement	Tableau de transition (progressants, régressants, stables) ; analyser les réponses appariées ; perdus de vue
Qualitatif	Entretiens, groupe de bilan, changement le plus significatif ; codage thématique en 5 étapes
Animation	Grille d'observation (8 critères, /32) ; auto-évaluation ; ajustements
Équité	Indice de représentation = % participants / % population ; progression par groupe ; régression vers la moyenne
Environnement	Gaspillage en g par repas ; réduction en %
Oral	Titres-messages, chiffres sourcés, 1 diapositive par minute ; connaître ses chiffres, justifier, reconnaître ses limites

Fiches-outils du chapitre 9

Outil	Intitulé	Utilité
O9.1	Plan d'évaluation	Indicateurs complets, dès la conception
O9.2	Questionnaire de satisfaction accessible	Fin d'atelier, tous publics
O9.3	Grille d'observation des compétences	Évaluer sans écrit
O9.4	Analyse avant / après	Calculs et interprétation en 4 temps
O9.5	Grille des 6 critères	Jugement global du projet
O9.6	Plan de valorisation	Destinataires, supports, dates

O9.1 – Plan d'évaluation

Type : P = processus, R = résultat, I = impact. Responsable du recueil : .....

O9.2 – Questionnaire de satisfaction accessible

Question	Tout à fait	Plutôt oui	Plutôt non	Pas du tout	Commentaire
J'ai aimé l'atelier	☐	☐	☐	☐	
J'ai appris des choses utiles	☐	☐	☐	☐	
Les explications étaient claires	☐	☐	☐	☐	
Je vais refaire une recette à la maison	☐	☐	☐	☐	
Je me suis senti(e) à l'aise dans le groupe	☐	☐	☐	☐	

Ce qui m'a le plus plu : ..... Ce qui m'a gêné ou à améliorer : .....

Anonyme et facultatif. Possibilité de répondre à l'oral.

O9.3 – Grille d'observation des compétences

Compétence observée	P01	P02	P03	P04	P05	P06
Se laver les mains et respecter l'hygiène						
Lire le Nutri-Score et comparer deux produits						
Rincer et cuire des légumes secs						
Mesurer une portion avec un contenant courant						
Calculer le coût d'une portion						
Expliquer une astuce au groupe (faire dire)						

Codage : A = acquis ; EC = en cours ; NA = non acquis. Codes anonymes.

O9.4 – Analyse avant / après

Indicateur		Avant (n, %)	Après (n, %)	Évolution (points)	Cible	Atteinte (%)
Temps	Rédaction					
Constater						
Comparer						
Expliquer						
Nuancer						

Nuancer

O9.5 – Grille des 6 critères

Critère	Éléments de preuve	Appréciation (1-4)	Recommandation
Pertinence			
Cohérence			
Efficacité			
Efficience			
Impact (attendu / inattendu)			
Durabilité			

O9.6 – Plan de valorisation

Destinataire	Message clé	Support	Date	Responsable
Participants				
Structure et partenaires				
Financeurs				
Grand public				
Professionnels				
Décideurs				

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES

CHAPITRE

09

Démarche de projet (3) : évaluation et valorisation

Démarche de projet (3) | Évaluer | Interpréter | Valoriser | Pérenniser

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 9 106
Mode d'emploi du cahier 106
Partie 1 – Évaluer : finalités, moments, critères 108
Exercice 9.1 – La chaîne des effets (10 points) 109
Exercice 9.2 – Les moments et les finalités de l'évaluation (10 points) 111
Exercice 9.3 – Les six critères d'évaluation (12 points) 113
Exercice 9.4 – Évaluation, suivi ou contrôle ? (12 points) 115
Exercice 9.5 – Qui évalue ? (12 points) 116
Exercice 9.6 – Rédiger les questions évaluatives d'un projet (16 points) 118
Corrigés de la partie 1 120
Partie 2 – Les indicateurs et le plan d'évaluation 123
Exercice 9.7 – La fiche indicateur (10 points) 124
Exercice 9.8 – Classer les indicateurs (10 points) 126
Exercice 9.9 – Corriger des indicateurs mal construits (12 points) 127
Exercice 9.10 – Valeurs initiales et valeurs cibles (12 points) 129
Exercice 9.11 – Construire le plan d'évaluation (16 points) 131
Exercice 9.12 – Le temps et le coût de l'évaluation (16 points) 133
Corrigés de la partie 2 135
Partie 3 – Les méthodes et les outils de recueil 139
Exercice 9.13 – Choisir un plan d'évaluation (10 points) 140
Exercice 9.14 – Concevoir un questionnaire avant-après (12 points) 142
Exercice 9.15 – Adapter les outils au public (12 points) 144
Exercice 9.16 – Construire et exploiter une grille d'observation (12 points) 145
Exercice 9.17 – Les indicateurs indirects (14 points) 147
Exercice 9.18 – Taux de réponse et perdus de vue (16 points) 149
Corrigés de la partie 3 151
Partie 4 – Les calculs d'évaluation 154
Exercice 9.19 – Les taux du bilan (10 points) 155
Exercice 9.20 – Scores, progression et gain normalisé (12 points) 156
Exercice 9.21 – Le tableau de transition (12 points) 157
Exercice 9.22 – Le test de McNemar (14 points) 159
Exercice 9.23 – Coût et efficience de deux actions (14 points) 160
Exercice 9.24 – Le groupe de comparaison (16 points) 162
Corrigés de la partie 4 163
Partie 5 – Interpréter et juger 166
Exercice 9.25 – Interpréter un résultat en quatre temps (12 points) 167
Exercice 9.26 – Biais et limites d'une évaluation (12 points) 169
Exercice 9.27 – Les conclusions abusives (12 points) 171
Exercice 9.28 – Juger un programme avec RE-AIM (14 points) 173
Exercice 9.29 – Évaluer l'équité d'une action (14 points) 175
Exercice 9.30 – Effets inattendus et effets indésirables (14 points) 177
Corrigés de la partie 5 179
Partie 6 – L'évaluation qualitative 182
Exercice 9.31 – Choisir une méthode qualitative (10 points) 183
Exercice 9.32 – Le guide d'entretien (12 points) 185
Exercice 9.33 – Coder des verbatims (14 points) 186
Exercice 9.34 – Croiser le qualitatif et le quantitatif (14 points) 188
Exercice 9.35 – Évaluer son animation (12 points) 190

Exercice 9.36 – La mesure à distance (14 points) 191
Corrigés de la partie 6 193
Partie 7 – Valoriser et rendre compte 196
Exercice 9.37 – Valoriser auprès de chaque public (10 points) 197
Exercice 9.38 – Le compte rendu financier de la subvention (14 points) 199
Exercice 9.39 – La note aux élus (14 points) 201
Exercice 9.40 – Le poster du projet (12 points) 203
Exercice 9.41 – Restituer aux participants en respectant l'éthique (12 points) 205
Exercice 9.42 – Le graphique honnête (14 points) 206
Corrigés de la partie 7 207
Partie 8 – Décider, transférer et s'entraîner sur un cas complet 210
Exercice 9.43 – Décider après l'évaluation (10 points) 211
Exercice 9.44 – Analyser la transférabilité avec ASTAIRE (12 points) 213
Exercice 9.45 – La fiche de capitalisation (12 points) 215
Exercice 9.46 – Rédiger la partie « évaluation » du dossier (14 points) 217
Exercice 9.47 – Présenter l'évaluation à l'oral (12 points) 219
Exercice 9.48 – Cas complet : la « pause qui compte » d'une plateforme téléphonique (40 points) 221
Corrigés de la partie 8 225
Bilan : grille d'auto-évaluation 229

Cahier d'exercices – Chapitre 9

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 9 : finalités, moments et types d'évaluation, critères (OCDE, 2019), indicateurs et plan d'évaluation, méthodes et outils de recueil adaptés aux publics, calculs d'évaluation, réponses appariées, test simple, groupe de comparaison, interprétation et limites, RE-AIM, équité, évaluation qualitative, évaluation de l'animation, valorisation, compte rendu financier, pérennisation, transférabilité et capitalisation (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition », C3.3 « Participer à des activités de recherche appliquée en nutrition humaine » et C3.5 « Communiquer et interagir dans un contexte d'intervention en santé » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : la chaîne des effets, les six critères, les moments de l'évaluation, la fiche indicateur, les plans d'évaluation, le tableau de transition, la règle des quatre temps, le modèle RE-AIM, l'analyse qualitative, la valorisation selon le destinataire, la boucle d'amélioration.
- Calculer et interpréter : taux de réalisation, de présence, de couverture, de réponse et d'atteinte ; progression et gain normalisé ; tableau de transition et test de McNemar ; différence des évolutions et risque relatif ; coût par participant et par résultat ; écarts budgétaires et reversement ; indicateurs indirects ; apports d'une recette (Ciqual 2025).
- Rédiger les parties « évaluation », « bilan » et « perspectives » d'un dossier de projet, et les défendre à l'oral.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits de dossiers), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, communes, personnes, résultats d'enquêtes, prix et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025). Les textes officiels, les auteurs et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Traiter une question d'évaluation à l'examen

Pour chaque question, suivez quatre temps. D'abord, repérez pour chaque objectif sa valeur initiale, sa cible, son échéance et sa source, et vérifiez qui a répondu (avant, après, aux deux temps). Ensuite, faites les calculs en posant la formule, l'application numérique et le résultat avec l'effectif (« 9 sur 12, soit 75 % »). Puis interprétez en quatre temps : constater, comparer à l'objectif et à l'état initial, expliquer, nuancer. Enfin,

concluez par une décision (poursuivre, ajuster, arrêter, étendre) et par la façon de restituer le résultat. Une copie qui donne un pourcentage sans effectif, ou qui conclut qu'une action « a prouvé son efficacité » à partir de douze personnes, perd des points.

Partie 1 – Évaluer : finalités, moments, critères

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer ressources, activités, réalisations, résultats et impact, et les relier aux trois niveaux d'évaluation.
- Situer une évaluation dans le temps (ex ante, en cours, finale, à distance) et selon sa finalité (formative, sommative).
- Utiliser les six critères d'évaluation (OCDE, 2019) pour poser des questions évaluatives.
- Distinguer évaluation, suivi et contrôle.
- Choisir qui évalue : équipe, évaluateur externe, participants.
- Rédiger les questions évaluatives d'un projet.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Évaluer, c'est porter un **jugement de valeur** sur une action, à partir d'informations recueillies avec rigueur et de critères explicites, pour **décider** (poursuivre, ajuster, arrêter, étendre) et **rendre compte**.
- La chaîne des effets : ressources → activités → réalisations → résultats → impact. L'évaluation de **processus** porte sur la mise en œuvre ; l'évaluation des **résultats** sur les objectifs spécifiques ; l'évaluation d'**impact** sur l'objectif général.
- Moments : ex ante (avant), en cours ou intermédiaire, finale (ex post), à distance. Finalités : **formative** (améliorer pendant l'action), **sommative** (juger à la fin).
- Six critères (comité d'aide au développement de l'OCDE, révisés en 2019) : pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact, viabilité (durabilité).
- Le **suivi** recueille des données en continu ; le **contrôle** vérifie la conformité à une règle ; l'**évaluation** juge la valeur et recommande.

Exercice 9.1 – La chaîne des effets (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association « Les Jardins de la Gare » (structure fictive) a mené pendant un an un projet de jardinage et de cuisine pour des familles d'un quartier de la politique de la ville. Votre tutrice a noté en vrac des éléments du bilan et vous demande de les ranger avant d'écrire le rapport d'évaluation.

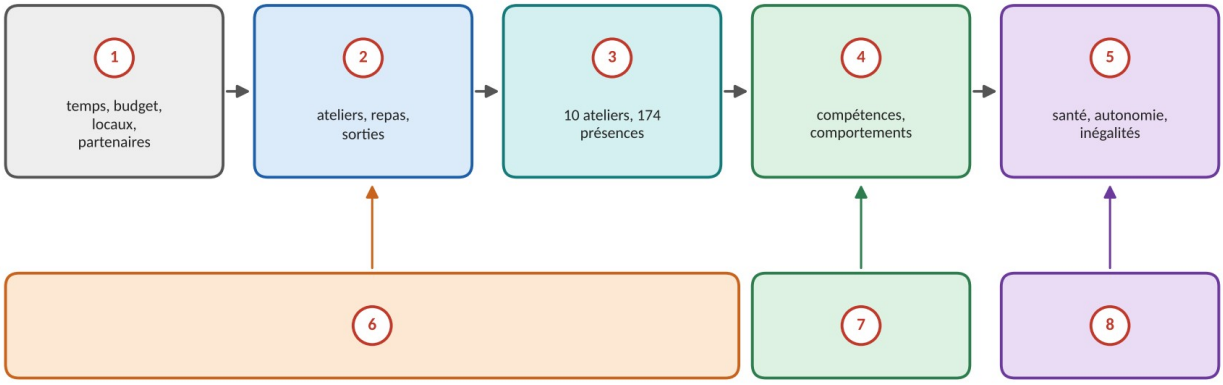


Figure 9.1 – Document 1 – La chaîne des effets et les trois niveaux d'évaluation (schéma à légender)

Document 2 – Dix éléments du bilan

a) 320 heures de bénévolat. b) 24 séances de jardinage réalisées. c) 15 familles déclarent cuisiner des légumes au moins quatre fois par semaine, contre 6 au départ. d) Un budget de 7 400 €. e) Des ateliers de cuisine avec les légumes récoltés. f) 410 kg de légumes récoltés. g) Une baisse du surpoids des enfants du quartier, que l'on espère à long terme. h) 18 familles savent préparer trois recettes de légumes de saison. i) Une parcelle de 600 m² prêtée par la ville. j) Un livret de 20 recettes distribué à 150 exemplaires.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (3 pts)
2. Rangez les dix éléments du document 2 dans les cinq maillons de la chaîne. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi l'élément g) ne peut pas être démontré par le projet de l'association. (1,5 pt)
4. Indiquez quel niveau d'évaluation un projet de stage doit toujours réaliser, et pourquoi. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.2 – Les moments et les finalités de l'évaluation (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de promotion de la santé d'une communauté d'agglomération (structure fictive) prépare un programme d'ateliers « Bien vieillir à table » dans six communes. La chargée de mission vous demande de prévoir les différents moments de l'évaluation.

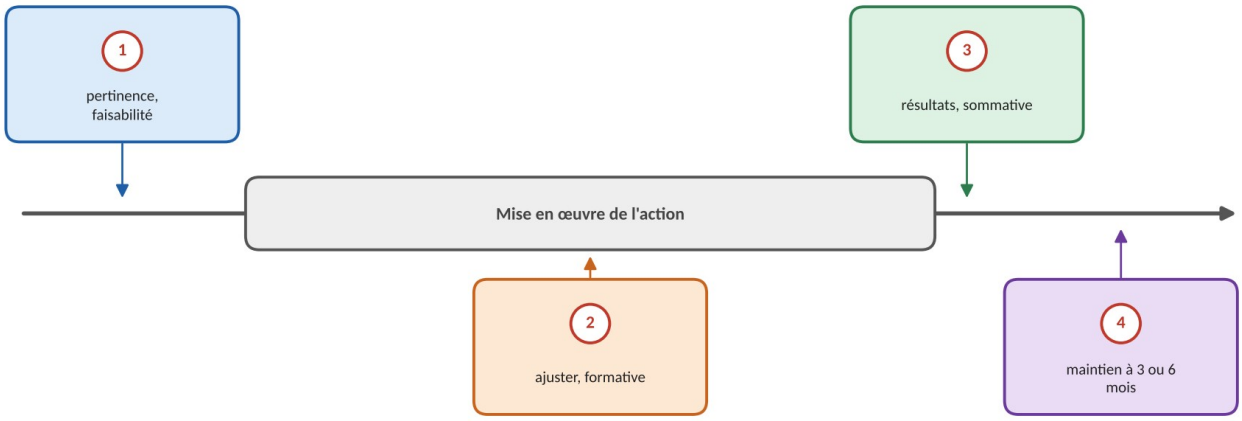


Figure 9.2 – Document 1 – Les moments de l'évaluation (schéma à légender)

Document 2 – Six situations d'évaluation

a) Avant de lancer le programme, on vérifie que les besoins sont réels et que les communes disposent de salles équipées.

b) Après les trois premiers ateliers, on interroge les participants pour modifier l'horaire et la durée des séances.

c) À la fin du programme, on mesure si les participants ont atteint les objectifs spécifiques.

d) Six mois après la fin, on appelle les participants pour savoir s'ils ont gardé les nouvelles habitudes.

e) À mi-parcours, l'animatrice remplit un carnet de bord et adapte les recettes aux remarques du groupe.

f) Le financeur reçoit le bilan final pour décider s'il renouvelle sa subvention.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Associez chaque situation du document 2 à un moment de l'évaluation. (3 pts)
3. Dites pour chaque situation si l'évaluation est plutôt formative ou plutôt sommative. Justifiez pour deux d'entre elles. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi l'état initial doit être mesuré avant le premier atelier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.3 – Les six critères d'évaluation (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de santé pluriprofessionnelle (structure fictive) a organisé un programme de marche et d'ateliers culinaires pour des patients sédentaires. Le comité de pilotage a listé des questions pour l'évaluation finale, sans les classer.

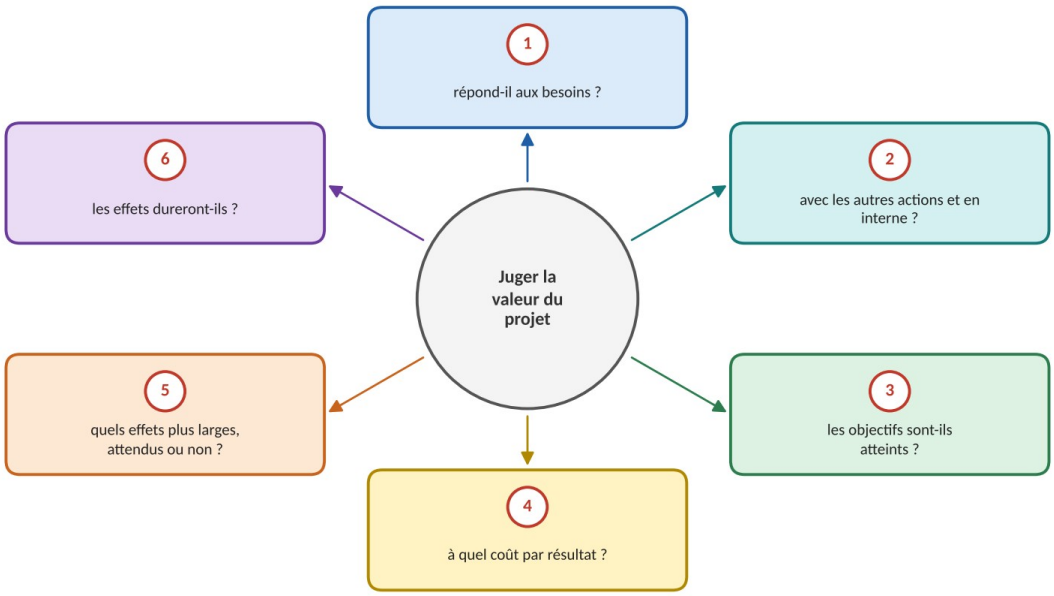


Figure 9.3 – Document 1 – Les six critères d'évaluation (OCDE, 2019) (schéma à légender)

Document 2 – Huit questions du comité de pilotage

a) Combien a coûté chaque patient qui marche désormais au moins 30 minutes trois fois par semaine ?

b) Le programme répondait-il aux besoins identifiés par les médecins et les patients ?

c) Les patients marchent-ils encore un an après la fin du programme ?

d) L'objectif « 60 % des patients marchent au moins 30 minutes trois fois par semaine » est-il atteint ?

e) Le programme était-il articulé avec le contrat local de santé et avec l'association de randonnée de la commune ?

f) Le programme a-t-il eu des effets non prévus, positifs ou négatifs, par exemple sur l'entourage des patients ?

g) Les ateliers culinaires étaient-ils cohérents avec les objectifs de marche et de nutrition fixés ?

h) Le programme peut-il continuer sans le financement de l'agence régionale de santé ?

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Classez les huit questions selon les six critères. (4 pts)
3. Proposez, pour chaque critère, l'indicateur ou la source qui permettra d'y répondre. (3 pts)
4. Expliquez la différence entre efficacité et efficience avec un exemple chiffré inventé. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.4 – Évaluation, suivi ou contrôle ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans un centre social (structure fictive) qui mène un projet « Cuisine et budget » financé par la caisse d'allocations familiales. La directrice vous dit : « On évalue tout le temps : on compte les présents, la CAF vérifie nos factures et on fait remplir un questionnaire de satisfaction. Je ne vois pas ce qu'il faut de plus. »

Document 1 – Ce que fait déjà le centre social

- Feuille d'émargement à chaque atelier ; tableau mensuel des présences.
- Tableau des dépenses mis à jour chaque mois, comparé au budget prévu.
- Contrôle des factures par la CAF à la fin de l'année.
- Questionnaire de satisfaction à la fin de chaque atelier (« Avez-vous aimé l'atelier ? Oui / Non »).
- Aucun objectif chiffré n'a été fixé dans la convention, en dehors du nombre d'ateliers (12).

À vous de jouer – Questions

1. Définissez le suivi, le contrôle et l'évaluation. (3 pts)
2. Classez chaque activité du document 1 dans l'une de ces trois catégories. (2,5 pts)
3. Expliquez à la directrice ce qui manque pour parler d'évaluation, en trois points. (3 pts)
4. Proposez deux objectifs spécifiques mesurables et l'outil qui permettra de les évaluer. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi un taux de satisfaction élevé ne suffit pas à juger un projet. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.5 – Qui évalue ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association d'aide alimentaire (structure fictive) a mené pendant deux ans un projet d'ateliers de cuisine dans quatre points de distribution. Le financeur demande une évaluation finale « indépendante ». Le budget disponible pour l'évaluation est de 3 000 €. Trois options sont envisagées.

Document 1 – Trois options pour l'évaluation

- **Option A – Auto-évaluation** par l'équipe salariée (deux animatrices et la coordinatrice), avec l'appui d'une stagiaire en diététique ; coût estimé : 600 € (temps de saisie et d'analyse).
- **Option B – Évaluation externe** par un cabinet spécialisé : entretiens, questionnaires, rapport ; devis : 2 900 €.
- **Option C – Évaluation participative** : un groupe de 6 bénévoles et 6 bénéficiaires, formé et accompagné par l'instance régionale de promotion de la santé, définit les questions, recueille et analyse les données avec l'équipe ; coût estimé : 1 800 € (formation, accompagnement, indemnités de transport).

À vous de jouer – Questions

1. Présentez, pour chaque option, deux avantages et deux limites. (4,5 pts)
2. Calculez la part du budget d'évaluation consommée par chaque option et ce qui reste. (1,5 pt)
3. Le financeur demande une évaluation « indépendante » : quelle option répond le mieux à cette demande ? Peut-on combiner deux options dans le budget ? Proposez une combinaison chiffrée. (3 pts)
4. Citez trois conditions éthiques d'une évaluation participative avec des bénéficiaires de l'aide alimentaire. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.6 – Rédiger les questions évaluatives d'un projet (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes stagiaire dans une mission locale rurale (structure fictive). Le projet « Mon premier frigo » accompagne des jeunes de 18 à 25 ans qui viennent d'entrer dans leur premier logement : 6 ateliers de cuisine, un panier de démarrage (ustensiles, épices, féculents) et un accompagnement aux courses. Votre tutrice vous demande de préparer l'évaluation dès la conception, en commençant par les questions évaluatives.

Document 1 – Extraits de la fiche projet (données fictives)

- Diagnostic : sur 40 jeunes interrogés en janvier 2028, 26 déclarent sauter au moins un repas par jour faute de savoir cuisiner ou de matériel, 31 mangent des plats préparés au moins quatre fois par semaine.
- Objectif général : contribuer à l'autonomie alimentaire des jeunes accompagnés par la mission locale.
- Objectif spécifique : en juin 2028, au moins 60 % des jeunes participants préparent eux-mêmes au moins un repas chaud par jour.
- Objectifs opérationnels : 6 ateliers de 2 heures pour 10 jeunes ; 10 paniers de démarrage ; 4 sorties au supermarché ; un livret de 15 recettes à moins de 2 € la portion.
- Budget : 3 600 €. Partenaires : épicerie sociale, bailleur social, conseillère en économie sociale et familiale.

À vous de jouer – Questions

1. Rédigez une question évaluative pour chacun des six critères de l'OCDE, adaptée à ce projet. (6 pts)
2. Pour chaque question, indiquez le niveau (processus, résultats, impact) et une source d'information. (4 pts)
3. Identifiez la question qui sera la plus difficile à traiter dans le temps du projet, et expliquez comment la traiter quand même. (3 pts)
4. Calculez les deux pourcentages du diagnostic. Expliquez pourquoi ils ne peuvent pas servir de valeur initiale pour l'objectif spécifique. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 9.1

1. Légendes : 1 Ressources ; 2 Activités ; 3 Réalisations ; 4 Résultats ; 5 Impact ; 6 Évaluation de processus ; 7 Évaluation des résultats ; 8 Évaluation d'impact.
2. **Ressources** : a) 320 heures de bénévolat, d) budget de 7 400 €, i) parcelle prêtée. **Activités** : e) ateliers de cuisine avec les légumes récoltés. **Réalisations** : b) 24 séances réalisées, f) 410 kg récoltés, j) livret distribué à 150 exemplaires. **Résultats** : c) 15 familles cuisinent des légumes au moins quatre fois par semaine (contre 6), h) 18 familles savent préparer trois recettes. **Impact** : g) baisse du surpoids des enfants à long terme.
3. Le surpoids des enfants dépend de très nombreux facteurs (revenus, école, activité physique, offre alimentaire, génétique) ; il évolue lentement ; le projet ne touche qu'une partie des familles du quartier ; il faudrait un suivi de plusieurs années et un groupe de comparaison. L'impact est donc **argumenté** à partir de la littérature (les comportements favorables obtenus vont dans le bon sens), pas démontré.
4. Un projet de stage évalue toujours le **processus** (a-t-on fait ce qui était prévu, pour le public prévu, avec les moyens prévus ?) et les **résultats** (les objectifs spécifiques sont-ils atteints ?). Ce sont les seuls niveaux mesurables dans la durée d'un stage, et ce sont eux qui permettent de décider de la suite.

Corrigé – Exercice 9.2

1. Légendes : 1 Ex ante ; 2 En cours (intermédiaire) ; 3 Finale (ex post) ; 4 À distance.
2. a) Ex ante ; b) en cours ; c) finale ; d) à distance ; e) en cours ; f) finale.
3. a) Formative (elle sert à ajuster la conception avant de commencer ; on parle aussi d'évaluation de la pertinence et de la faisabilité) ; b) **formative** : les résultats servent immédiatement à modifier l'horaire et la durée ; c) sommative ; d) sommative (elle juge le maintien des effets ; elle peut aussi servir à concevoir la prochaine édition) ; e) formative ; f) **sommative** : le bilan sert à porter un jugement global et à prendre une décision de financement. Une même évaluation peut avoir les deux finalités.
4. Sans mesure avant le premier atelier, il n'y a pas d'« avant » : on ne pourra pas savoir ce qui a changé. Les réponses recueillies après plusieurs ateliers seraient déjà influencées par l'action. L'état initial est aussi la valeur de départ des indicateurs, à partir de laquelle on fixe une valeur cible réaliste.

Corrigé – Exercice 9.3

1. Légendes : 1 Pertinence ; 2 Cohérence ; 3 Efficacité ; 4 Efficience ; 5 Impact ; 6 Viabilité.
2. **Pertinence** : b. **Cohérence** : e (cohérence externe) et g (cohérence interne). **Efficacité** : d. **Efficience** : a. **Impact** : f. **Viabilité** : c et h.
3. Pertinence : comparaison des objectifs au diagnostic et aux priorités du projet régional de santé. Cohérence : analyse documentaire (contrat local de santé, conventions), entretiens avec les partenaires. Efficacité : questionnaire avant et après, part des patients qui marchent au moins 30 minutes trois fois par semaine. Efficience : coût total divisé par le nombre de patients ayant atteint l'objectif. Impact : entretiens avec les patients et leur entourage, carnet de bord. Viabilité : recueil à un an, plan de financement de l'année suivante.
4. L'efficacité compare le résultat à l'objectif ; l'efficience compare le résultat aux moyens. Exemple : le programme A fait marcher 12 patients sur 20 (60 %, objectif atteint) pour 6 000 €, soit 500 € par patient ayant atteint l'objectif ; le programme B fait marcher 9 patients sur 20 (45 %, objectif non atteint) pour 2 700 €, soit 300 € par patient. A est plus efficace, B est plus efficient : le choix dépend de l'objectif et du budget.

Corrigé – Exercice 9.4

1. **Suivi** : recueil continu de données sur le déroulement de l'action (présences, dépenses, délais), pour

piloter. **Contrôle** : vérification de la conformité à une règle (usage de la subvention, respect d'une norme). **Évaluation** : jugement sur la valeur de l'action au regard de ses objectifs et de critères explicites, pour décider et recommander.

2. Émargement et tableau des présences : suivi. Tableau des dépenses comparé au budget : suivi (pilotage budgétaire). Contrôle des factures par la CAF : contrôle. Questionnaire de satisfaction : c'est une donnée d'évaluation, mais très partielle (une seule question fermée).

3. Il manque : des **objectifs spécifiques chiffrés** avec une valeur initiale et une valeur cible (sans objectif, on ne peut pas juger) ; une **mesure des changements** chez les participants (connaissances, pratiques de cuisine, gestion du budget), avant et après ; une **analyse** qui compare les résultats aux objectifs, explique les écarts, reconnaît les limites et aboutit à des **recommandations**.

4. Exemples : « En fin de cycle, 70 % des participants préparent au moins quatre repas maison par semaine » (questionnaire avant et après, réponses appariées) ; « 80 % des participants savent calculer le coût d'une portion à partir d'un ticket de caisse » (mise en situation au dernier atelier, grille d'observation).

5. La satisfaction mesure le plaisir ressenti, pas le changement : on peut aimer un atelier sans rien modifier dans sa cuisine. Les participants satisfaits sont aussi ceux qui reviennent (les insatisfaits sont absents), et la réponse « oui » est influencée par la relation avec l'animatrice (désirabilité sociale). La satisfaction est un indicateur de processus utile, pas un indicateur de résultat.

Corrigé – Exercice 9.5

1. **Option A** : avantages – connaissance fine du projet et du public, coût faible, apprentissage de l'équipe ; limites – manque de recul et d'indépendance (l'équipe juge son propre travail), temps pris sur l'action. **Option B** : avantages – indépendance et crédibilité auprès du financeur, méthodes maîtrisées ; limites – coût élevé, connaissance limitée du terrain, risque que l'équipe ne s'approprie pas les conclusions. **Option C** : avantages – place donnée aux personnes concernées, questions pertinentes, renforcement du pouvoir d'agir, appropriation des résultats ; limites – temps long, formation nécessaire, risque de pression sociale entre bénévoles et bénéficiaires, indépendance discutable vis-à-vis de l'association.

2. A : 600 / 3 000 × 100 = **20 %**, reste 2 400 € ; B : 2 900 / 3 000 × 100 = **96,7 %**, reste 100 € ; C : 1 800 / 3 000 × 100 = **60 %**, reste 1 200 €.

3. L'option B répond le mieux à la demande d'indépendance, mais elle épuise le budget. On peut combiner : **C + A**, soit 1 800 + 600 = 2 400 € (80 %), avec un regard extérieur apporté par l'instance régionale de promotion de la santé ; ou demander au cabinet un devis réduit pour une **supervision externe** (validation du protocole et de l'analyse) de 1 200 €, ajoutée à l'option C : 1 800 + 1 200 = 3 000 €, soit 100 % du budget. On en discute avec le financeur, qui doit accepter que l'indépendance soit garantie par une supervision.

4. Le **consentement libre** : participer à l'évaluation n'est jamais une condition pour recevoir l'aide alimentaire. La **confidentialité** : les bénéficiaires qui recueillent des données ne doivent pas accéder aux informations nominatives des autres ; anonymisation. La **protection contre les pressions** : les bénévoles ne sont pas en position d'autorité sur les bénéficiaires dans le groupe ; on prévoit une animation neutre. On peut ajouter la juste reconnaissance du temps donné (indemnités de transport) et la restitution des résultats au groupe.

Corrigé – Exercice 9.6

1. Exemples de questions évaluatives :

- **Pertinence** : le projet répond-il aux difficultés des jeunes (absence de matériel, manque de savoir-faire, plats préparés) identifiées dans le diagnostic ?
- **Cohérence** : les ateliers, le panier et les sorties forment-ils un ensemble cohérent avec l'objectif ? Le projet s'articule-t-il avec l'accompagnement au logement du bailleur et de la conseillère en économie sociale et familiale ?

- **Efficacité** : au moins 60 % des participants préparent-ils un repas chaud par jour en juin 2028 ?
- **Efficience** : combien coûte chaque jeune qui a atteint l'objectif ? Le panier de démarrage est-il une dépense utile au regard des résultats ?
- **Impact** : quels effets inattendus (entraide entre jeunes, économies, effet sur le maintien dans le logement) ?
- **Viabilité** : les jeunes cuisinent-ils encore trois mois après ? La mission locale peut-elle poursuivre sans financement spécifique ?

2. Pertinence : niveau conception (ex ante) et processus ; source : diagnostic, entretiens. Cohérence : processus ; source : fiche projet, conventions, entretiens avec les partenaires. Efficacité : résultats ; source : questionnaire avant et après, réponses appariées. Efficience : résultats et processus ; source : budget réalisé et résultats. Impact : impact et effets inattendus ; source : entretiens, carnet de bord. Viabilité : à distance ; source : appel à trois mois, plan de financement.

3. La **viabilité** (et l'impact) : on ne peut pas mesurer dans le temps du projet ce qui se passera après. On la traite quand même avec un recueil à distance (appel à trois mois aux jeunes volontaires), en analysant les conditions de la pérennisation (relais, outils, financement) et en s'appuyant sur des expériences comparables.

4. Repas sautés : 26 / 40 × 100 = **65,0 %** ; plats préparés au moins quatre fois par semaine : 31 / 40 × 100 = **77,5 %**. Ces chiffres portent sur 40 jeunes interrogés en janvier, qui ne seront pas tous participants, et sur d'autres questions que celle de l'objectif (« préparer soi-même un repas chaud par jour »). La valeur initiale doit être mesurée **chez les participants, au premier atelier, avec la même question** que celle qui sera posée à la fin.

Partie 2 – Les indicateurs et le plan d'évaluation

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer et compléter les éléments d'une fiche indicateur.
- Classer un indicateur : ressources, activité, participation, satisfaction, résultat, impact.
- Repérer et corriger un indicateur mal construit.
- Calculer une valeur initiale et fixer une valeur cible réaliste.
- Construire le plan d'évaluation complet d'un projet.
- Estimer le temps et le coût de l'évaluation et juger sa proportionnalité.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Un **indicateur** est une variable observable et mesurable. Sa fiche précise : intitulé, mode de calcul (numérateur et dénominateur), valeur initiale, valeur cible et échéance, source (outil), moment et fréquence du recueil, responsable.
- Six familles : ressources (moyens), activité ou réalisation (ce qui a été fait), participation (qui a été touché), satisfaction (perception), résultat (changements chez le public), impact (effets à long terme).
- Un objectif spécifique se mesure par un indicateur de **résultat** ; un objectif opérationnel par un indicateur d'**activité** ou de **participation**.
- La valeur cible se fixe à partir de la valeur initiale, du diagnostic, de la littérature et des moyens ; elle doit être ambitieuse et atteignable.
- Le **plan d'évaluation** se rédige en même temps que les objectifs, avant l'action ; il prévoit le temps de recueil, de saisie et d'analyse.

Exercice 9.7 – La fiche indicateur (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution et application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une épicerie solidaire rurale (structure fictive), un cycle d'ateliers « Légumes secs, petits prix » commence. Au premier atelier, 14 participants ont rempli un court questionnaire : 4 déclarent consommer des légumes secs au moins deux fois par semaine. L'objectif spécifique fixé avec la responsable est : « À la fin du cycle, en mai 2028, au moins 60 % des participants consomment des légumes secs au moins deux fois par semaine. »

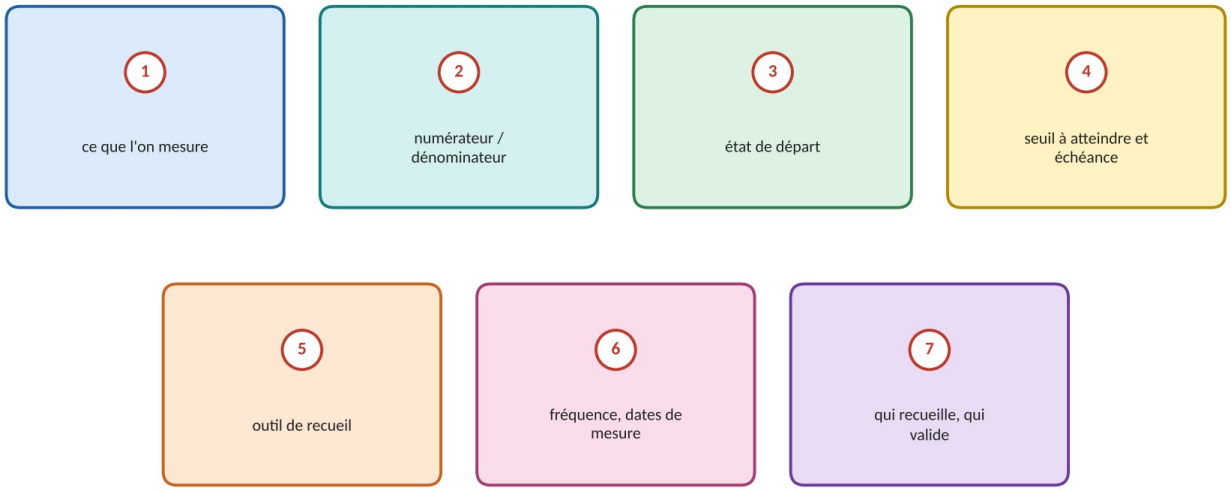


Figure 9.4 – Document 1 – Les éléments d'une fiche indicateur (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)
2. Calculez la valeur initiale de l'indicateur et le nombre minimal de participants qui devront atteindre le repère à la fin pour que l'objectif soit atteint (si les 14 participants répondent). (2 pts)
3. Rédigez la fiche indicateur complète. (3,5 pts)
4. Que se passe-t-il pour le calcul si seuls 11 participants répondent au questionnaire final ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.8 – Classer les indicateurs (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne d'un service de prévention départemental (structure fictive) prépare le tableau de bord d'un programme « Petits-déjeuners en famille » dans six écoles maternelles. Elle a listé douze indicateurs possibles.

Document 1 – Douze indicateurs

a) Nombre d'heures de diététicienne consacrées au programme. b) Nombre de petits-déjeuners pédagogiques réalisés sur 12 prévus. c) Part des familles invitées qui sont venues au moins une fois. d) Part des parents qui déclarent que leur enfant prend un petit-déjeuner chaque jour d'école. e) Note moyenne de satisfaction des parents. f) Budget dépensé par rapport au budget prévu. g) Nombre de kits « petit-déjeuner » distribués. h) Part des enseignants qui estiment que les enfants sont plus attentifs en début de matinée. i) Part des familles participantes qui vivent dans un quartier prioritaire. j) Évolution de la prévalence de l'obésité chez les enfants de grande section du département en cinq ans. k) Part des enfants capables de citer trois aliments d'un petit-déjeuner complet. l) Nombre de partenaires engagés (écoles, PMI, centres sociaux).

À vous de jouer – Questions

1. Classez les douze indicateurs en six familles : ressources, activité, participation, satisfaction, résultat, impact. (6 pts)
2. Indiquez les deux indicateurs qui serviront à juger l'objectif spécifique « augmenter la part des enfants qui prennent un petit-déjeuner chaque jour d'école », et précisez leur limite. (2 pts)
3. Pourquoi l'indicateur j) ne peut-il pas figurer dans le bilan du programme ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.9 – Corriger des indicateurs mal construits (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le dossier de projet d'une stagiaire, pour un projet dans un foyer de vie pour adultes handicapés (structure fictive), contient le tableau d'indicateurs ci-dessous. Sa tutrice vous demande de l'aider à le corriger avant le dépôt.

Document 1 – Six indicateurs à corriger

N°	Indicateur proposé
1	« Les résidents mangent mieux. »
2	« Nombre de résidents qui boivent de l'eau. »
3	« Taux de satisfaction : 90 %. »
4	« Part des résidents qui ont progressé au questionnaire » (questionnaire écrit de 20 questions, alors que la moitié des résidents ne lisent pas).
5	« Nombre d'ateliers. »
6	« Poids moyen des résidents en fin de projet » (projet de 8 semaines).

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque indicateur, nommez le défaut principal (non mesurable, sans dénominateur, sans valeur initiale ni cible, outil inadapté, sans référence au prévu, hors de portée du projet). (6 pts)
2. Réécrivez chaque indicateur de façon correcte, avec son calcul et une cible. (6 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.10 – Valeurs initiales et valeurs cibles (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un club de prévention spécialisée (structure fictive) accompagne des adolescents de 14 à 17 ans. Avant de lancer un projet « Bien manger quand on traîne dehors », les éducateurs ont fait remplir un court questionnaire imagé à 25 jeunes participants.

Document 1 – Résultats du questionnaire initial (25 jeunes, données fictives)

Question	Réponses « oui »
Je prends quelque chose le matin avant de partir, chaque jour	11
Je bois de l'eau plutôt qu'un soda au déjeuner, la plupart du temps	13
Je mange au moins un fruit par jour	7

Document 2 – Informations pour fixer les cibles

- Dans une action comparable menée en 2026 dans un autre quartier (données fictives), la part des jeunes mangeant un fruit chaque jour est passée de 30 % à 46 % en quatre mois.
- Le projet dure quatre mois, avec 8 rencontres ; les jeunes ne sont pas tous présents à chaque rencontre.
- Le club peut proposer chaque semaine des fruits gratuits pendant les rencontres.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les trois valeurs initiales. (1,5 pt)
2. Une stagiaire propose des cibles de 100 % pour les trois indicateurs. Expliquez pourquoi ce n'est pas réaliste. (2 pts)
3. Proposez une valeur cible pour chaque indicateur, en pourcentage et en nombre de jeunes, et justifiez-la à l'aide du document 2. (4,5 pts)
4. Rédigez l'objectif spécifique correspondant à l'indicateur « fruit » sous une forme SMART. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi il faut garder exactement la même formulation des questions au questionnaire final. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.11 – Construire le plan d'évaluation (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes stagiaire dans un service d'aide et d'accompagnement à domicile (structure fictive). Le projet « Les repas qui font du bien » forme 12 aides à domicile au repérage de la dénutrition et à l'aide à la préparation de repas enrichis, puis suit 40 personnes âgées qu'elles accompagnent. Votre tutrice vous demande le plan d'évaluation complet avant le lancement.

Document 1 – Les objectifs du projet (septembre 2027 à mars 2028)

- **OS1** : en mars 2028, 100 % des 12 aides à domicile formées savent repérer trois signes d'alerte de dénutrition et peser une personne avec la balance du service.
- **OS2** : en mars 2028, au moins 80 % des 40 personnes suivies ont été pesées au moins une fois par mois.
- **OS3** : en mars 2028, la part des personnes suivies qui ont perdu plus de 5 % de leur poids en un mois ou plus de 10 % en six mois diminue par rapport à septembre (repères de perte de poids utilisés dans les critères de la Haute Autorité de santé, 2021).
- **Objectifs opérationnels** : 3 demi-journées de formation ; 1 balance par secteur (4 secteurs) ; 1 fiche de suivi par personne ; 2 réunions d'analyse de pratiques.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez le plan d'évaluation sous forme de tableau : pour chaque objectif (spécifiques et opérationnels), l'indicateur, le calcul, la valeur initiale (à mesurer ou connue), la cible, l'outil, le moment et le responsable. (9 pts)
2. Ajoutez deux indicateurs de processus qui ne figurent pas dans les objectifs mais qui seront utiles au pilotage. (2 pts)
3. Proposez une méthode qualitative pour comprendre comment les aides à domicile vivent ce nouveau rôle. (2 pts)
4. Citez trois précautions éthiques liées au recueil du poids des personnes âgées. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.12 – Le temps et le coût de l'évaluation (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de quartier (structure fictive) a un budget de projet de 5 600 € pour un cycle d'ateliers de cuisine avec 25 participants. La coordinatrice vous demande d'estimer le temps et le coût de l'évaluation que vous proposez, puis de l'alléger si elle dépasse 15 % du budget. Le coût horaire chargé de la personne qui évalue est de 24 € (donnée fournie par l'association) ; les impressions coûtent 40 €.

Document 1 – Le protocole d'évaluation proposé

Tâche	Hypothèse de durée
Concevoir et tester le questionnaire	4 h
Faire passer le questionnaire en entretien individuel, avant et après	10 min par personne et par passage
Saisir les questionnaires	5 min par questionnaire
Analyser les données (tableur)	6 h
Mener 6 entretiens qualitatifs	45 min chacun
Transcrire mot à mot et analyser les entretiens	1 h 30 par entretien
Rédiger le rapport	8 h

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le temps total de l'évaluation, en détaillant chaque ligne. (4 pts)
2. Calculez le coût de l'évaluation et sa part dans le budget du projet. (2 pts)
3. Proposez deux allègements qui ne nuisent pas à la qualité de l'évaluation, recalculez le temps, le coût et la part du budget. (5 pts)
4. Expliquez ce qu'on appelle la proportionnalité de l'évaluation et donnez deux situations où une évaluation plus lourde se justifie. (3 pts)
5. Indiquez une tâche qu'il ne faut jamais supprimer, et pourquoi. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 9.7

1. Légendes : 1 Intitulé ; 2 Mode de calcul ; 3 Valeur initiale ; 4 Valeur cible ; 5 Source ; 6 Moment ; 7 Responsable.

2. Valeur initiale : 4 / 14 × 100 = **28,6 %**. Cible : 60 % × 14 = 8,4 ; il faut au moins **9 participants** (on arrondit à l'entier supérieur, car 8 participants donneraient 57,1 %).

3. Fiche indicateur :

Élément	Contenu
Intitulé	Part des participants consommant des légumes secs au moins deux fois par semaine
Calcul	Nombre de participants déclarant au moins deux fois par semaine / nombre de participants ayant répondu × 100
Valeur initiale	28,6 % (4 sur 14, questionnaire du premier atelier)
Valeur cible	Au moins 60 % en mai 2028
Source	Question 3 du questionnaire avant et après, même formulation, code anonyme
Moment	Premier et dernier atelier ; appel à trois mois si possible
Responsable	Stagiaire (passation et saisie) ; responsable de l'épicerie (validation)

4. Le dénominateur devient 11 : on calcule la part sur les répondants et l'on analyse en priorité les **réponses appariées** (les 11 personnes présentes aux deux temps), en recalculant leur valeur initiale. On signale 3 perdus de vue. Il faudra alors 0,6 × 11 = 6,6, soit au moins **7 participants** sur 11.

Corrigé – Exercice 9.8

1. **Ressources** : a) heures de diététicienne, f) budget dépensé, l) partenaires engagés. **Activité** : b) petits-déjeuners réalisés, g) kits distribués. **Participation** : c) familles venues, i) part des familles en quartier prioritaire (profil des participants, équité). **Satisfaction** : e) note des parents. **Résultat** : d) petit-déjeuner chaque jour d'école, k) enfants capables de citer trois aliments, h) attention en début de matinée selon les enseignants. **Impact** : j) prévalence de l'obésité en cinq ans.

2. d) (part des enfants qui prennent un petit-déjeuner chaque jour d'école, déclaré par les parents) : limite – donnée déclarative, désirabilité sociale ; et h) (observation des enseignants) : limite – perception subjective, influencée par d'autres facteurs (sommeil, saison). On peut ajouter un relevé un jour donné en classe (« qu'as-tu mangé ce matin ? »), avec l'accord des parents.

3. Le programme ne peut pas, à lui seul et en quelques mois, modifier la prévalence de l'obésité de tout un département : l'effet serait trop faible et mêlé à de nombreux autres facteurs, et il faudrait plusieurs années de suivi. C'est un indicateur d'**impact** qui sert à situer le programme dans un objectif général, pas à évaluer ce programme.

Corrigé – Exercice 9.9

1. Défauts : 1 – **non mesurable** (« mieux » n'est pas défini). 2 – **sans dénominateur, sans valeur initiale ni cible** (un nombre seul ne dit rien). 3 – c'est un **résultat**, pas un indicateur ; il manque l'outil, la question posée et le dénominateur. 4 – **outil inadapté** au public (questionnaire écrit pour des personnes qui ne lisent pas). 5 – **sans référence au prévu** (nombre d'ateliers sans comparaison à ce qui était prévu). 6 – **hors de portée** du projet (le poids moyen évolue peu en huit semaines et dépend de nombreux facteurs ; une moyenne cache les situations individuelles).

2. Réécritures possibles :

- 1 : « Part des résidents qui mangent au moins une portion de légumes au déjeuner, observée sur 5 jours

avant et après (grille d'observation en salle à manger) ; valeur initiale à mesurer ; cible : + 20 points. »

- 2 : « Part des résidents qui choisissent l'eau au déjeuner, sur 5 jours d'observation, avant et après ; cible : au moins 70 %. »
- 3 : « Part des résidents qui choisissent le visage souriant sur une échelle à trois visages à la fin de chaque atelier ; présences comme dénominateur ; cible : au moins 80 %. »
- 4 : « Part des résidents qui réussissent au moins 4 des 5 gestes observés (grille d'observation adaptée, avec images) au dernier atelier ; cible : 70 %. »
- 5 : « Taux de réalisation des ateliers : ateliers réalisés / 8 prévus × 100 ; cible : 100 %. »
- 6 : remplacé par « part des résidents pesés au moins une fois par mois pendant le projet » (processus) et, pour le résultat, par un indicateur de comportement (indicateur 1 ou 2) ; le poids ne se suit qu'individuellement, avec l'équipe soignante.

Corrigé – Exercice 9.10

1. Matin : 11 / 25 = **44 %** ; eau au déjeuner : 13 / 25 = **52 %** ; fruit chaque jour : 7 / 25 = **28 %**.

2. Une cible de 100 % suppose que tous les jeunes changent, alors que certains ne viendront qu'à une partie des rencontres, que les habitudes dépendent aussi de la famille, de l'argent et des amis, et qu'en quatre mois les changements sont progressifs. Une cible inatteignable décourage l'équipe et rend l'évaluation négative d'avance.

3. Exemples de cibles : **fruit** : l'action comparable a gagné 16 points (30 % à 46 %) ; avec des fruits gratuits chaque semaine, on peut viser + 20 points, soit 28 + 20 = **48 %**, c'est-à-dire 0,48 × 25 = **12 jeunes**. **Matin** : + 20 points, soit **64 %**, 0,64 × 25 = **16 jeunes**. **Eau** : + 20 points, soit **72 %**, 0,72 × 25 = **18 jeunes**. Les cibles sont ambitieuses mais proches de ce qui a été observé ailleurs ; on les ajustera si l'on constate une présence faible.

4. « D'ici la fin juin 2028 (quatre mois), au moins 48 % des jeunes participants (contre 28 % au départ) déclarent manger au moins un fruit par jour, mesuré par le même questionnaire imagé à la première et à la dernière rencontre. »

5. Si la formulation change (« un fruit par jour » devient « des fruits souvent »), les réponses ne sont plus comparables : une évolution pourrait venir de la question elle-même, et non d'un changement de comportement. On garde aussi le même mode de passation (imagé, avec un éducateur) et le même moment de la journée.

Corrigé – Exercice 9.11

1. Plan d'évaluation (exemple) :

Objectif	Indicateur et calcul	Valeur initiale	Cible	Outil	Moment	Responsable
OS1	Part des aides à domicile qui citent 3 signes d'alerte et réalisent une pesée correcte : nombre qui réussissent / 12 × 100	À mesurer en début de formation (mise en situation)	100 % (12 sur 12)	Mise en situation et grille d'observation	Avant et après la formation, puis en mars	Diététicienne
OS2	Part des personnes suivies pesées au moins une fois par mois : nombre / 40 × 100	0 % (pas de pesée organisée)	Au moins 80 % (32 sur 40)	Fiches de suivi	Chaque mois	Responsable de secteur

Objectif	Indicateur et calcul	Valeur initiale	Cible	Outil	Moment	Responsable
OS3	Part des personnes suivies ayant perdu plus de 5 % en un mois ou plus de 10 % en six mois	À mesurer : première pesée en septembre, puis perte de poids connue (dossier, déclaration)	Diminution par rapport à septembre	Fiches de suivi, courbe de poids	Septembre et mars	Diététicienne, avec le médecin traitant
Formation	Demi-journées réalisées / 3 × 100 ; présence des aides à domicile	–	100 % ; au moins 11 sur 12 présentes à chaque demi-journée	Émargements	Après chaque formation	Stagiaire
Balances	Secteurs équipés / 4 × 100	0	100 %	Inventaire	Octobre	Responsable de service
Fiches de suivi	Personnes ayant une fiche / 40 × 100	0	100 %	Dossiers	Novembre	Responsables de secteur
Analyse de pratiques	Réunions réalisées / 2 × 100	–	100 %	Comptes rendus	Décembre et février	Diététicienne

2. Exemples : nombre d'alertes transmises au médecin ou à l'infirmière (fiche d'alerte) ; part des personnes suivies qui ont reçu au moins une proposition d'enrichissement des repas ; temps passé par les aides à domicile pour la pesée et le suivi (charge de travail).

3. Un **groupe de discussion** avec 6 à 8 aides à domicile en fin de projet, avec un guide de questions (ce qui a changé dans leur travail, difficultés, réactions des personnes âgées, besoins de soutien), animé par une personne qui n'est pas leur supérieure ; ou des entretiens individuels courts. Analyse thématique des réponses.

4. Le **consentement** de la personne âgée à être pesée et à ce que son poids soit noté, après une explication simple ; le **respect de la dignité et de l'intimité** (pesée à domicile, sans témoin, avec un matériel adapté et sécurisé pour éviter les chutes) ; la **confidentialité** des données de santé (fiches rangées, accès limité, transmission au médecin dans le cadre du partage d'informations entre professionnels autorisé). On peut ajouter : ne pas faire de la pesée une source d'inquiétude ou de culpabilité.

Corrigé – Exercice 9.12

1. Temps :

- Conception : **4 h**.
- Passation : 2 passages × 25 personnes × 10 min = 500 min = **8 h 20** (8,33 h).
- Saisie : 2 × 25 questionnaires × 5 min = 250 min = **4 h 10** (4,17 h).
- Analyse : **6 h**.
- Entretiens : 6 × 45 min = 270 min = **4 h 30**.
- Transcription et analyse : 6 × 1,5 h = **9 h**.
- Rédaction : **8 h**.
- Total : 4 + 8,33 + 4,17 + 6 + 4,5 + 9 + 8 = **44 h**.

2. Coût : 44 × 24 = 1 056 € ; avec les impressions : 1 056 + 40 = **1 096 €** ; part du budget : 1 096 / 5 600 × 100 = **19,6 %** : au-dessus du seuil de 15 % fixé par la coordinatrice.

3. Allègements possibles : faire passer le questionnaire **en petit groupe** au début et à la fin d'un atelier, avec une aide à la lecture (environ 30 minutes par passage, soit 1 h au lieu de 8 h 20) ; remplacer la transcription mot à mot par des **notes structurées** prises pendant l'entretien et complétées juste après (45 min par entretien au lieu de 1 h 30, soit 4 h 30 au lieu de 9 h). Nouveau total : 4 + 1 + 4,17 + 6 + 4,5 + 4,5 + 8 = **32,17 h** (32 h 10) ; coût : 32,17 × 24 = 772 € ; avec les impressions : **812 €** ; part : 812 / 5 600 × 100 = **14,5 %**, sous le seuil. La passation en groupe garde les mêmes questions ; il faut seulement veiller à

ce que chacun réponde seul (confidentialité, désirabilité).

4. La **proportionnalité** consiste à adapter l'ampleur et le coût de l'évaluation à l'enjeu et aux décisions qu'elle doit éclairer : une petite action ponctuelle n'a pas besoin du même dispositif qu'un programme coûteux. Une évaluation plus lourde se justifie par exemple quand le projet est **expérimental** et qu'on envisage de l'étendre à d'autres territoires, ou quand il **engage des fonds importants** ou un public vulnérable, avec un risque d'effets indésirables à surveiller.
5. La **mesure de l'état initial** (questionnaire avant) : sans elle, aucune comparaison n'est possible et l'évaluation des résultats perd presque tout son sens. On peut aussi citer l'analyse et la restitution des résultats.

Partie 3 – Les méthodes et les outils de recueil

Objectifs – Objectifs de la partie

- Choisir un plan d'évaluation adapté à la situation et en connaître les limites.
- Concevoir un questionnaire avant-après exploitable (questions identiques, code anonyme).
- Adapter les outils de recueil au public (enfants, personnes peu lectrices, personnes âgées, personnes handicapées).
- Construire et exploiter une grille d'observation des compétences.
- Utiliser des indicateurs indirects (ventes, restes, inscriptions).
- Calculer les taux de réponse et repérer le biais lié aux perdus de vue.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Plans d'évaluation : après seulement (aucune comparaison) ; avant-après chez les mêmes personnes ; avant-après avec groupe de comparaison ; essai contrôlé randomisé (référence de la recherche, rarement possible sur le terrain) ; méthodes qualitatives ; méthodes mixtes (souvent le meilleur compromis).
- Questionnaire avant-après : **mêmes questions, même formulation, même mode de passation**, **code anonyme** pour apparier les réponses (par exemple deux lettres du prénom de la mère et le jour de naissance).
- Outils adaptés : échelles imagées (visages, météo), photolangage, grille d'observation, aliments réels, entretien oral, FALC.
- Indicateur **indirect** : mesure objective d'un effet probable (ventes, restes, inscriptions) ; utile, mais il ne mesure pas directement ce que mangent les personnes.
- Les **perdus de vue** (présents avant, absents après) ne sont pas des personnes « comme les autres » : on compare leur profil initial à celui des personnes suivies.

Exercice 9.13 – Choisir un plan d'évaluation (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une réunion du réseau départemental de promotion de la santé (réseau fictif), quatre structures présentent leur projet et demandent quel plan d'évaluation choisir.

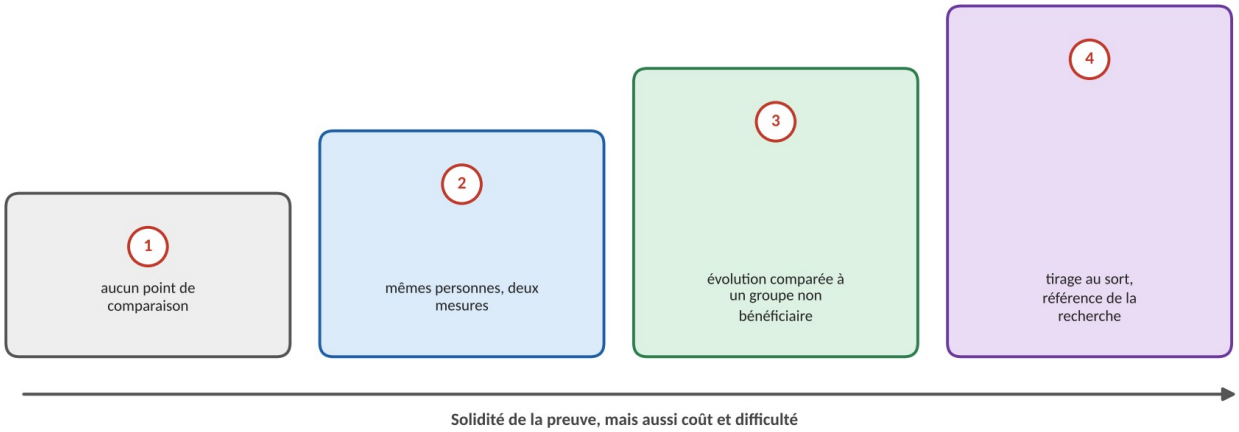


Figure 9.5 – Document 1 – Les plans d'évaluation (schéma à légender)

Document 2 – Quatre situations

a) Un centre social organise une seule journée « Fête de la soupe » ; il veut savoir si les visiteurs ont apprécié et ce qu'ils ont retenu.

b) Une ville finance des ateliers de cuisine dans deux de ses quatre maisons de quartier cette année, et dans les deux autres l'année suivante.

c) Une mutuelle étudiante veut comparer deux applications d'aide à la planification des repas ; 400 étudiants volontaires sont prêts à participer ; un laboratoire universitaire l'accompagne.

d) Une association mène un cycle de 8 ateliers avec 12 participants et veut mesurer les changements de pratiques.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Proposez pour chaque situation le plan d'évaluation le plus adapté et justifiez. (6 pts)
3. Expliquez pourquoi on ne peut pas, dans la situation d), priver la moitié des participants d'ateliers pour créer un groupe témoin. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.14 – Concevoir un questionnaire avant-après (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire prépare l'évaluation d'ateliers « Cuisine du placard » pour des familles accompagnées par une association de lutte contre la précarité (structure fictive). Elle vous montre son questionnaire avant et son questionnaire après.

Document 1 – Extraits des deux questionnaires

Questionnaire avant (premier atelier)

- Q1. Nom et prénom : …
- Q2. Cuisinez-vous souvent ? Oui / Non
- Q3. Combien de fois par semaine mangez-vous des légumes secs (lentilles, pois chiches, haricots) ? Jamais / 1 fois / 2 fois ou plus
- Q4. Ne pensez-vous pas qu'il est important de manger moins de plats préparés ? Oui / Non
- Q5. Combien dépensez-vous par mois pour l'alimentation et l'hygiène ? …

Questionnaire après (dernier atelier)

- Q1. Nom et prénom : …
- Q2. Cuisinez-vous plus souvent qu'avant ? Oui / Non
- Q3. Mangez-vous des légumes secs plus souvent grâce aux ateliers ? Oui / Non
- Q4. Avez-vous aimé les ateliers ? Oui / Non
- Q5. Combien dépensez-vous par mois pour l'alimentation ? …

À vous de jouer – Questions

1. Relevez six défauts dans ces questionnaires. (6 pts)
2. Proposez un système de code anonyme qui permette d'apparier les réponses sans recueillir de nom. (2 pts)
3. Réécrivez les questions 2 et 3 pour qu'elles soient identiques avant et après, précises et non orientées. (2 pts)
4. Indiquez deux règles de passation pour limiter la désirabilité sociale. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.15 – Adapter les outils au public (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne coordonne l'évaluation de quatre projets menés par une même fondation (fondation fictive). Les outils prévus sont les mêmes partout : un questionnaire écrit de 25 questions, rempli seul, en fin de projet.

Document 1 – Les quatre publics

a) Des enfants de 6 et 7 ans dans un accueil de loisirs.

b) Des adultes qui apprennent le français dans un atelier sociolinguistique.

c) Des personnes de plus de 80 ans vivant à domicile, dont plusieurs ont des troubles de la vue.

d) Des adultes avec une déficience intellectuelle travaillant dans un ESAT.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi l'outil prévu ne convient à aucun des quatre publics. (2 pts)
2. Proposez, pour chaque public, deux outils adaptés (un pour les résultats, un pour la satisfaction), en précisant les adaptations. (8 pts)
3. Citez deux précautions communes à tous ces publics. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.16 – Construire et exploiter une grille d'observation (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Au dernier atelier d'un cycle « Cuisiner avec un petit budget » dans un centre d'hébergement (structure fictive), l'éducatrice a observé 10 participants pendant la préparation d'un plat. Elle a noté 1 si la compétence est réussie sans aide, 0 sinon.

Document 1 – Grille d'observation (10 participants, données fictives)

Participant	A – Se laver les mains au bon moment	B – Peser ou mesurer les ingrédients	C – Calculer le coût d'une portion	D – Cuire les légumes secs	E – Lire la liste des ingrédients et repérer les allergènes
P1	1	1	1	1	1
P2	1	1	0	1	0
P3	1	0	0	1	0
P4	1	1	1	1	1
P5	0	0	0	1	0
P6	1	1	1	1	0
P7	1	1	0	0	0
P8	1	1	0	1	1
P9	1	0	1	1	0
P10	1	1	0	0	0

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de réussite de chaque compétence et classez les compétences de la mieux à la moins bien acquise. (3 pts)
2. Calculez le score de chaque participant (sur 5) et la part des participants qui réussissent au moins 4 compétences sur 5. (3 pts)
3. L'objectif opérationnel était : « au moins 70 % des participants réussissent au moins 4 compétences sur 5 ». Jugez-le et proposez deux ajustements pour le cycle suivant. (3 pts)
4. Citez trois règles pour qu'une grille d'observation soit fiable. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.17 – Les indicateurs indirects (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Deux projets ont utilisé des indicateurs indirects. Dans une épicerie solidaire (structure fictive), un cycle d'ateliers sur les légumes secs a eu lieu en avril. Dans un restaurant scolaire (structure fictive), une action de sensibilisation contre le gaspillage a été menée avec les élèves.

Document 1 – Ventes de légumes secs à l'épicerie (en kg, données fictives)

Avant les ateliers	Janvier	Février	Mars
Ventes	18	21	19

Après les ateliers	Mai	Juin	Juillet
Ventes	34	38	41

En mai, l'épicerie a aussi baissé le prix des lentilles en vrac de 20 %.

Document 2 – Pesée des restes au restaurant scolaire (moyenne sur 5 jours, données fictives)

Période	Poids servi par jour (kg)	Restes par jour (kg)
Avant l'action (novembre)	48,0	17,3
Après l'action (février)	46,5	11,2

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les ventes totales et mensuelles moyennes avant et après, et l'évolution en pourcentage. (3 pts)
2. Calculez le taux de restes avant et après, et l'évolution en points. (2 pts)
3. Pour chaque projet, expliquez ce que l'indicateur indirect permet de dire et ce qu'il ne permet pas de dire. Identifiez au moins un facteur de confusion dans chaque cas. (5 pts)
4. Proposez, pour chacun, un recueil complémentaire qui renforcerait la conclusion. (2 pts)
5. Pourquoi les indicateurs indirects sont-ils appréciés des financeurs ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.18 – Taux de réponse et perdus de vue (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service de santé universitaire (structure fictive) a proposé un cycle de 6 ateliers « Cuisiner dans 9 m² » à 30 étudiants inscrits. La stagiaire a recueilli un questionnaire de connaissances (score sur 10) au premier et au dernier atelier. Elle écrit dans son bilan : « Le score moyen est passé de 4,8 au début à 6,9 à la fin : les ateliers ont fait progresser les étudiants de 2,1 points. »

Document 1 – Les données du recueil (données fictives)

- 30 inscrits ; 26 questionnaires au premier atelier ; 19 au dernier atelier ; 17 étudiants ont répondu aux deux.
- Score moyen au premier atelier : 4,8 sur les 26 répondants.
- Score moyen au dernier atelier : 6,9 sur les 19 répondants.
- Pour les 17 étudiants qui ont répondu aux deux : score moyen 5,2 au début et 6,8 à la fin.
- Pour les 9 étudiants qui ont répondu seulement au début : score moyen 3,9 au début.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les taux de réponse au premier et au dernier atelier (par rapport aux inscrits), la part des réponses appariées et le nombre de perdus de vue parmi les répondants du premier atelier. (4 pts)

2. Expliquez l'erreur de raisonnement de la stagiaire. (3 pts)

3. Calculez la progression réelle chez les 17 étudiants suivis. Comparez-la à celle annoncée. (2 pts)

4. Comparez le score initial des étudiants perdus de vue à celui des étudiants suivis, et expliquez ce que cela change à l'interprétation. (3 pts)

5. Proposez trois moyens de réduire le nombre de perdus de vue lors d'un prochain cycle. (3 pts)

6. Rédigez la phrase correcte qui doit figurer dans le bilan. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 9.13

1. Légendes : 1 Après seulement ; 2 Avant / après ; 3 Avant / après avec groupe de comparaison ; 4 Essai contrôlé randomisé.
2. a) **Après seulement**, complété par quelques questions qualitatives : pour une action ponctuelle, une mesure avant n'a pas grand sens ; on interroge les visiteurs à la sortie (satisfaction, une ou deux idées retenues), sans prétendre mesurer un changement de comportement. b) **Avant-après avec groupe de comparaison** : les deux maisons de quartier qui commencent l'année suivante servent de comparaison pendant la première année, sans priver personne (déploiement décalé). c) **Essai contrôlé randomisé** : les effectifs sont importants, les volontaires peuvent être tirés au sort entre les deux applications, et un laboratoire peut garantir la méthode. d) **Avant-après chez les mêmes personnes**, avec réponses appariées, complété par des méthodes qualitatives (méthode mixte).
3. Avec 12 participants, un groupe témoin de 6 personnes n'apporterait pas de conclusion solide (effectifs trop faibles) ; surtout, refuser l'action à des personnes qui en ont besoin et qui l'ont demandée pose un problème **éthique**, sans bénéfice scientifique. On préfère la mesure avant-après, une description honnête des limites, et éventuellement une comparaison avec des données extérieures.

Corrigé – Exercice 9.14

1. Défauts : Q1 – **nom et prénom** : le questionnaire n'est pas anonyme (désirabilité sociale, confidentialité) ; Q2 – « **souvent** » est flou, et la question **change** entre avant et après (« plus souvent qu'avant ») ; Q3 – question **différente** avant (fréquence) et après (oui/non, « grâce aux ateliers »), donc pas de comparaison possible, et la question après est **orientée** (elle suggère l'effet) ; Q4 avant – question **orientée** (« Ne pensez-vous pas… ») ; Q4 après – satisfaction, qui ne remplace pas la question avant ; Q5 – la question **change** (« alimentation et hygiène » puis « alimentation ») et elle est intrusive sans justification.
2. Exemple de code : les deux premières lettres du prénom de la mère, le jour de naissance de la personne et la dernière lettre de son prénom (« MA-14-E »). La personne peut le reconstituer seule aux deux passages ; il ne permet pas de l'identifier.
3. Q2 (avant et après) : « La semaine dernière, combien de repas avez-vous préparés vous-même à partir d'ingrédients de base ? 0 / 1 à 3 / 4 à 7 / 8 ou plus. » Q3 (avant et après) : « La semaine dernière, combien de fois avez-vous mangé des légumes secs (lentilles, pois chiches, haricots) ? Jamais / 1 fois / 2 fois ou plus. »
4. Faire remplir le questionnaire de manière **anonyme**, si possible par une personne qui n'anime pas les ateliers ; expliquer qu'il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse et que le but est d'améliorer les ateliers ; laisser chacun répondre seul, sans regard des autres, avec une aide à la lecture neutre si nécessaire.

Corrigé – Exercice 9.15

1. Un questionnaire écrit de 25 questions, rempli seul, suppose de savoir lire, de comprendre le français écrit, d'avoir une bonne vue et une capacité de concentration suffisante. Aucun des quatre publics ne remplit toutes ces conditions.
2. Exemples :

- a) **Enfants de 6-7 ans** : résultats – jeu de tri d'images d'aliments ou dessin « mon goûter », observation pendant l'atelier ; satisfaction – échelle à trois visages ou gommettes sur une affiche. Adaptations : consignes orales, durée courte, en petit groupe, accord des parents.
- b) **Apprenants en français** : résultats – photolangage et mise en situation (« montre ce que tu achètes pour un repas complet »), aliments réels ; satisfaction – échelle imagée, échange oral avec un interprète ou un participant relais. Adaptations : vocabulaire simple, images, traduction des consignes.
- c) **Personnes de plus de 80 ans** : résultats – entretien oral court, éventuellement par téléphone, rappel de ce qui a été mangé la veille ; satisfaction – question orale avec une échelle simple en très gros caractères.

Adaptations : temps, calme, gros caractères, contraste, aide d'un proche si la personne le souhaite.

- d) **Adultes avec une déficience intellectuelle** : résultats – grille d'observation des gestes en atelier, choix d'images ; satisfaction – échelle à trois visages, question ouverte simple. Adaptations : FALC, pictogrammes, relecture par des personnes concernées, présence d'un éducateur connu.

3. Recueillir le **consentement** avec des explications adaptées (orales, imagées) et respecter un refus ; tester l'outil auprès de quelques personnes avant de l'utiliser (prétest) ; garantir la confidentialité ; restituer les résultats sous une forme accessible.

Corrigé – Exercice 9.16

1. A : 9 / 10 = **90 %** ; B : 7 / 10 = **70 %** ; C : 4 / 10 = **40 %** ; D : 8 / 10 = **80 %** ; E : 3 / 10 = **30 %**. Classement : A (90 %), D (80 %), B (70 %), C (40 %), E (30 %). Taux global : 31 réussites sur 50 observations, soit **62 %**.

2. Scores : P1 = 5 ; P2 = 3 ; P3 = 2 ; P4 = 5 ; P5 = 1 ; P6 = 4 ; P7 = 2 ; P8 = 4 ; P9 = 3 ; P10 = 2. Participants avec au moins 4 sur 5 : P1, P4, P6, P8, soit **4 sur 10 = 40 %**.

3. L'objectif (70 %) **n'est pas atteint** (40 %). Les gestes pratiques (hygiène, cuisson) sont acquis ; les compétences qui demandent de **calculer** (coût) et de **lire** (ingrédients, allergènes) sont les plus faibles. Ajustements : simplifier les supports (étiquettes agrandies, repérage des allergènes avec un code couleur, calcul du coût avec une fiche guidée et une calculatrice) ; consacrer un atelier entier à ces deux compétences, avec répétition. On peut aussi revoir la cible si elle était trop ambitieuse pour ce public, en l'expliquant.

4. Définir chaque compétence par un **comportement observable** et un critère de réussite précis (« se lave les mains avant de toucher les aliments et après avoir cassé les œufs ») ; former les observateurs et, si possible, faire observer quelques participants par deux personnes pour vérifier qu'elles notent de la même façon ; observer dans les mêmes conditions pour tous (même recette, même moment), sans aider pendant l'observation.

Corrigé – Exercice 9.17

1. Ventes avant : 18 + 21 + 19 = **58 kg**, soit 58 / 3 = **19,3 kg** par mois ; après : 34 + 38 + 41 = **113 kg**, soit **37,7 kg** par mois. Évolution : (113 − 58) / 58 × 100 = **+ 94,8 %** (presque un doublement).

2. Taux de restes avant : 17,3 / 48,0 × 100 = **36,0 %** ; après : 11,2 / 46,5 × 100 = **24,1 %** ; évolution : **− 11,9 points**.

3. Épicerie : l'indicateur montre que les familles achètent beaucoup plus de légumes secs après les ateliers ; il ne dit pas qui les achète (participants ou non), ni s'ils sont cuisinés et mangés. Facteur de confusion : la **baisse du prix de 20 %** en mai, qui suffit à augmenter les ventes ; on peut aussi citer la saison. **Restaurant scolaire** : l'indicateur montre que les restes diminuent ; il ne dit pas si les élèves mangent mieux (ils peuvent manger plus de féculents et laisser les légumes), ni si l'effet durera. Facteurs de confusion : **les menus différents** entre novembre et février, la quantité servie qui a un peu baissé, des absences d'élèves.

4. Épicerie : interroger les participants sur leurs achats et leur consommation (questionnaire avant-après), ou suivre les achats des participants avec leur accord sur leur carte d'adhérent. Restaurant : pesée par composante (entrée, plat, légumes, dessert) avec les mêmes menus avant et après, et observation des plateaux.

5. Ils sont **objectifs** (non déclaratifs), souvent **déjà disponibles** donc peu coûteux, faciles à suivre dans le temps et faciles à comprendre ; ils parlent un langage concret (kilos, euros, gaspillage).

Corrigé – Exercice 9.18

1. Taux de réponse : premier atelier 26 / 30 = **86,7 %** ; dernier atelier 19 / 30 = **63,3 %** ; réponses appariées 17 / 30 = **56,7 %** des inscrits (17 / 26 = **65,4 %** des répondants du premier atelier). Perdus de vue parmi

les répondants du premier atelier : 26 − 17 = **9**.

2. La stagiaire compare deux **groupes différents** : 26 étudiants au début et 19 à la fin, dont seulement 17 sont communs. La différence de moyenne mélange l'effet des ateliers et le changement de composition du groupe : si les étudiants qui partent sont ceux qui avaient les scores les plus bas, la moyenne de fin monte mécaniquement.

3. Chez les 17 étudiants suivis : 6,8 − 5,2 = **+ 1,6 point**, au lieu des 2,1 points annoncés. La progression a été surestimée de 0,5 point.

4. Les perdus de vue avaient un score initial de **3,9**, contre **5,2** pour les étudiants suivis : ce sont les étudiants qui en savaient le moins qui sont partis. La progression de 1,6 point ne concerne que les étudiants les plus à l'aise au départ ; on ne sait rien de l'effet sur les autres. C'est un **biais d'attrition** : il faut le signaler et se demander pourquoi les étudiants les moins avancés ont quitté le cycle (horaires, contenu trop difficile, sentiment d'échec).

5. Choisir des horaires compatibles avec les cours (enquête avant le cycle) ; envoyer un rappel la veille par message ; prévoir le questionnaire final à l'avant-dernier atelier ou le proposer en ligne aux absents ; rendre le cycle attractif jusqu'au bout (dernier atelier festif, remise d'un livret) ; contacter les étudiants absents pour comprendre et les inviter à revenir.

6. « Chez les 17 étudiants présents au premier et au dernier atelier, le score moyen de connaissances est passé de 5,2 à 6,8 sur 10 (+ 1,6 point) ; 9 étudiants, dont le score initial était plus faible (3,9), n'ont pas répondu à la fin, ce qui limite la portée du résultat. »

Partie 4 – Les calculs d'évaluation

Objectifs – Objectifs de la partie

- Calculer les taux de réalisation, de présence, de couverture et d'atteinte d'un objectif.
- Calculer une progression, un gain normalisé, une médiane, et comparer des sous-groupes.
- Construire et lire un tableau de transition.
- Appliquer le test de McNemar et en connaître les conditions.
- Calculer un coût par participant et un coût par résultat, et comparer l'efficience de deux actions.
- Exploiter un groupe de comparaison : différence des évolutions, risque relatif et intervalle de confiance.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Taux de réalisation = réalisé / prévu × 100. Taux de présence = présences / (séances × inscrits) × 100. Taux de couverture = participants / public cible × 100. Taux d'atteinte = valeur obtenue / valeur cible × 100.
- Progression = après − avant (en points pour un pourcentage). Gain normalisé = (moyenne après − moyenne avant) / (maximum − moyenne avant).
- Tableau de transition : stables positifs, progression, régression, stables négatifs. Part ayant progressé parmi ceux qui pouvaient progresser = progressions / (« non » avant) × 100.
- Test de McNemar (avec correction de continuité) : $\chi^2 = (|b - c| - 1)^2 / (b + c)$; significatif au risque de 5 % si $\chi^2 > 3{,}84$; peu fiable si $b + c < 10$.
- Coût par participant = coût / participants ; coût par résultat = coût / personnes ayant atteint l'objectif.
- Intervalle de confiance du risque relatif : $\exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{(1/a - 1/(a + b) + 1/c - 1/(c + d))})$. S'il contient 1, la différence n'est pas significative.

Exercice 9.19 – Les taux du bilan (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – calcul guidé · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le club de retraités « Les Tilleuls bleus » (structure fictive), qui compte 210 adhérents, a organisé 8 séances « Bouger et bien manger » pour 15 inscrits. L'objectif spécifique était : « En fin de cycle, au moins 70 % des participants pratiquent au moins 30 minutes de marche par jour. » Au dernier atelier, 13 participants ont répondu au questionnaire, dont 9 déclarent marcher au moins 30 minutes par jour.

Document 1 – Présences aux 8 séances

Séance	1	2	3	4	5	6	7	8
Présents	14	13	12	13	11	12	10	12

Une séance « sortie au marché » prévue en plus des 8 séances n'a pas eu lieu (pluie) ; 7 activités annexes sur 8 prévues ont été réalisées.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de réalisation des séances et des activités annexes. (1,5 pt)
2. Calculez le nombre total de présences et le taux de présence. (2 pts)
3. Calculez le taux de couverture des adhérents du club. (1,5 pt)
4. Calculez le résultat de l'objectif spécifique et son taux d'atteinte. Concluez. (3 pts)
5. Pourquoi faut-il toujours donner l'effectif à côté du pourcentage dans ce bilan ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.20 – Scores, progression et gain normalisé (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un cycle d'ateliers sur la lecture des étiquettes a été proposé à 12 aidants familiaux dans une plateforme d'accompagnement (structure fictive). Un quiz de 10 questions a été passé au premier et au dernier atelier.

Document 1 – Scores sur 10 (réponses appariées, données fictives)

Code	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
Avant	3	5	4	6	2	5	7	4	3	6	5	4
Après	6	7	6	8	5	7	8	6	5	8	7	6

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la moyenne et la médiane avant et après. (3 pts)
2. Calculez la progression moyenne et le gain normalisé ; interprétez le gain normalisé. (2,5 pts)
3. Calculez la progression moyenne des aidants qui avaient 4 ou moins au départ et celle des autres. Que constatez-vous ? (2,5 pts)
4. Calculez le nombre d'aidants qui ont au moins 7 sur 10 avant et après. (1 pt)
5. Citez deux raisons pour lesquelles les aidants qui partaient de plus bas peuvent avoir davantage progressé, sans que l'atelier en soit la seule cause. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.21 – Le tableau de transition (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un foyer de jeunes en insertion (structure fictive), 20 jeunes ont participé à un projet « Je prépare mon petit-déjeuner ». La question posée avant et après était : « Prenez-vous quelque chose à manger le matin au moins 5 jours sur 7 ? »

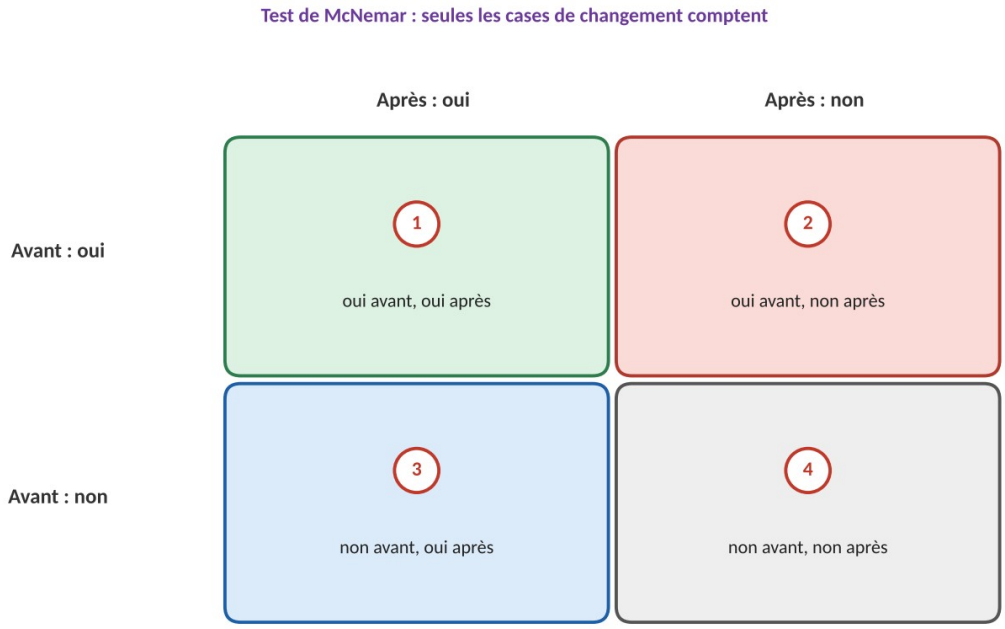


Figure 9.6 – Document 1 – Le tableau de transition des réponses appariées (schéma à légender)

Document 2 – Les réponses des 20 jeunes (données fictives)

- 6 jeunes répondent « oui » avant et « oui » après.
- 2 jeunes répondent « oui » avant et « non » après.
- 8 jeunes répondent « non » avant et « oui » après.
- 4 jeunes répondent « non » avant et « non » après.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)

2. Construisez le tableau de transition avec les totaux. (2 pts)

3. Calculez les pourcentages avant et après, et l'évolution en points. (2 pts)

4. Calculez la part des jeunes qui ont progressé parmi ceux qui pouvaient progresser, et la part de ceux qui ont régressé parmi ceux qui pouvaient régresser. (3 pts)

5. Expliquez ce que le tableau de transition apporte de plus que la comparaison des deux pourcentages. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.22 – Le test de McNemar (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – calcul et interprétation · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous reprenez les données de l'exercice 9.21 et un second indicateur du même projet. Votre tutrice vous demande si les changements observés peuvent être dus au hasard.

Document 1 – Les cases de changement (20 jeunes)

Indicateur	Oui → non (b)	Non → oui (c)
Prendre quelque chose le matin au moins 5 jours sur 7	2	8
Boire de l'eau plutôt qu'une boisson sucrée le matin	1	11

Rappel : $\chi^2 = (|b - c| - 1)^2 / (b + c)$; valeur seuil au risque de 5 % : 3,84 ; test peu fiable si $b + c < 10$.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le χ^2 de McNemar pour chaque indicateur et concluez au risque de 5 %. (4 pts)
2. Pourquoi le test n'utilise-t-il pas les jeunes « stables » ? (2 pts)
3. Le premier indicateur montre une progression de 30 points, mais le test n'est pas significatif. Expliquez ce résultat. (3 pts)
4. Rédigez, pour chaque indicateur, la phrase de conclusion qui figurera dans le bilan. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi un résultat significatif ne prouve pas que le projet est la cause du changement. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.23 – Coût et efficience de deux actions (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté de communes (structure fictive) a financé deux actions pour améliorer la consommation de légumes des familles. Elle ne peut en reconduire qu'une seule l'an prochain et vous demande une analyse.

Document 1 – Les deux actions (données fictives)

	Action A : cycle de 6 ateliers de cuisine	Action B : distribution de bons d'achat de légumes au marché, avec une fiche recette
Coût total	4 200 €	1 500 €
Participants	30	60
Participants ayant atteint l'objectif (légumes au moins deux fois par jour, mesuré à la fin)	12	9
Autres effets observés	18 participants savent cuisiner trois recettes ; un groupe d'entraide s'est créé	Bons utilisés à 92 % ; effet surtout pendant la période de distribution

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque action, le coût par participant, la part de participants ayant atteint l'objectif et le coût par participant ayant atteint l'objectif. (4,5 pts)
2. Calculez le coût de chaque résultat supplémentaire obtenu par l'action A par rapport à l'action B. (2 pts)
3. Quelle action est la plus efficace ? la plus efficiente ? Justifiez. (2,5 pts)
4. Quels éléments, autres que le coût par résultat, faut-il prendre en compte pour décider ? (3 pts)
5. Proposez une décision argumentée. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.24 – Le groupe de comparaison (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une caisse de retraite (structure fictive) a financé des ateliers « Bien manger, bien vieillir » dans une commune, et a interrogé aux mêmes dates des retraités d'une commune voisine qui n'ont pas eu d'ateliers. L'indicateur est : « manger au moins trois fois par semaine un produit laitier au dîner ».

Document 1 – Résultats (données fictives)

Groupe	Effectif	Oui avant	Oui après
Participants aux ateliers	40	12	26
Retraités de la commune voisine	38	11	14

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages avant et après dans chaque groupe, et l'évolution en points. (3 pts)

2. Calculez la différence des évolutions. Que représente-t-elle ? (2 pts)

3. Calculez le risque relatif en fin de projet et son intervalle de confiance à 95 %. Concluez. (5 pts)

4. Citez trois conditions pour que la commune voisine soit un bon groupe de comparaison. (3 pts)

5. Expliquez pourquoi on ne doit pas comparer seulement les pourcentages de fin de projet. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 9.19

1. Séances : 8 / 8 = **100 %** ; activités annexes : 7 / 8 = **87,5 %**.
2. Présences : 14 + 13 + 12 + 13 + 11 + 12 + 10 + 12 = **97** ; présences possibles : 8 × 15 = 120 ; taux de présence : 97 / 120 × 100 = **80,8 %**.
3. Couverture : 15 / 210 × 100 = **7,1 %** des adhérents.
4. Résultat : 9 / 13 × 100 = **69,2 %** ; taux d'atteinte : 69,2 / 70 × 100 = **98,9 %**. L'objectif n'est **pas atteint**, mais de très peu : il aurait fallu 10 participants sur 13 (76,9 %), soit une personne de plus. On le dit honnêtement, en soulignant que le résultat est proche de la cible et en vérifiant la situation des 2 participants qui n'ont pas répondu.
5. Avec 13 répondants, une seule personne représente 7,7 points : un pourcentage seul donne une fausse impression de précision. L'effectif permet au lecteur de juger la portée du résultat et de ne pas le généraliser.

Corrigé – Exercice 9.20

1. Somme avant : 3 + 5 + 4 + 6 + 2 + 5 + 7 + 4 + 3 + 6 + 5 + 4 = 54 ; moyenne : 54 / 12 = **4,5**. Somme après : 6 + 7 + 6 + 8 + 5 + 7 + 8 + 6 + 5 + 8 + 7 + 6 = 79 ; moyenne : 79 / 12 = **6,58**. Médianes (6e et 7e valeurs classées) : avant (4 + 5) / 2 = **4,5** ; après (6 + 7) / 2 = **6,5**.
2. Progression moyenne : 6,58 − 4,5 = **+ 2,08 points**. Gain normalisé : 2,08 / (10 − 4,5) = 2,08 / 5,5 = **0,38** : les aidants ont gagné un peu plus d'un tiers de ce qu'il leur restait à apprendre.
3. Aidants à 4 ou moins (A1, A3, A5, A8, A9, A12) : progressions 3, 2, 3, 2, 2, 2, soit 14 / 6 = **2,33 points**. Autres (A2, A4, A6, A7, A10, A11) : 2, 2, 2, 1, 2, 2, soit 11 / 6 = **1,83 point**. Les aidants qui partaient de plus bas ont progressé davantage : l'atelier semble avoir réduit les écarts dans le groupe.
4. Au moins 7 sur 10 : **1** aidant avant (A7), **6** après (A2, A4, A6, A7, A10, A11).
5. **Effet plafond** : ceux qui avaient déjà 6 ou 7 ne pouvaient gagner que 3 ou 4 points au maximum ; **régression vers la moyenne** : un score très bas au premier passage peut être dû en partie au hasard (fatigue, stress) et remonter au second ; on peut aussi citer l'**effet d'apprentissage** du quiz (on retient les questions).

Corrigé – Exercice 9.21

1. Légendes : 1 Stables positifs ; 2 Régression ; 3 Progression ; 4 Stables négatifs.
2. Tableau de transition :

Avant ↓ / Après →	Oui	Non	Total avant
Oui	6	2	8
Non	8	4	12
Total après	14	6	20

3. Avant : 8 / 20 = **40 %** ; après : 14 / 20 = **70 %** ; évolution : **+ 30 points**.
4. Progression parmi ceux qui pouvaient progresser : 8 / 12 = **66,7 %**. Régression parmi ceux qui pouvaient régresser : 2 / 8 = **25 %**.
5. La comparaison des pourcentages (40 % puis 70 %) cache les mouvements individuels : on pourrait obtenir la même évolution avec 6 progressions et aucune régression, ou avec 8 progressions et 2 régressions. Le tableau montre que **deux jeunes ont arrêté** de manger le matin : c'est une information utile pour comprendre (changement d'horaire de travail, difficultés) et ajuster l'accompagnement. Il est aussi la base du test de McNemar.

Corrigé – Exercice 9.22

1. Matin : $\chi^2 = (|2 - 8| - 1)^2 / (2 + 8) = 5^2 / 10 = 25 / 10 =$ **2,50** < 3,84 : **non significatif** au risque de 5 % (b + c = 10, à la limite de fiabilité du test). Eau : $\chi^2 = (|1 - 11| - 1)^2 / (1 + 11) = 9^2 / 12 = 81 / 12 =$ **6,75** > 3,84 : **significatif** (b + c = 12).
2. Les jeunes stables (oui-oui ou non-non) n'ont pas changé : ils n'apportent aucune information sur le sens du changement. Le test regarde seulement si les changements se font davantage dans un sens que dans l'autre.
3. Le test ne repose que sur 10 changements (8 progressions et 2 régressions). Avec si peu de changements, un déséquilibre de 8 contre 2 peut encore apparaître par hasard assez souvent. La progression de 30 points est réelle dans ce groupe, mais l'effectif est trop faible pour exclure le hasard : on manque de **puissance**.
4. Matin : « La part des jeunes qui prennent quelque chose le matin au moins 5 jours sur 7 est passée de 8 à 14 sur 20 ; cette évolution est encourageante, mais l'effectif ne permet pas d'exclure le hasard (test de McNemar non significatif). » Eau : « 11 jeunes ont remplacé la boisson sucrée du matin par de l'eau et 1 a fait l'inverse ; ce changement est statistiquement significatif au risque de 5 % (test de McNemar). »
5. Le test dit seulement que le déséquilibre observé a peu de chances d'être dû au hasard de l'échantillon. D'autres causes peuvent l'expliquer : une campagne nationale, un changement dans le foyer (nouveaux horaires, distributeur retiré), la désirabilité sociale des réponses. Sans groupe de comparaison, on ne peut pas attribuer le changement au seul projet.

Corrigé – Exercice 9.23

1. **A** : coût par participant 4 200 / 30 = **140 €** ; part ayant atteint l'objectif 12 / 30 = **40 %** ; coût par participant ayant atteint l'objectif 4 200 / 12 = **350 €**. **B** : 1 500 / 60 = **25 €** ; 9 / 60 = **15 %** ; 1 500 / 9 = **166,67 €**.
2. Résultats supplémentaires : 12 − 9 = 3 ; coût supplémentaire : 4 200 − 1 500 = 2 700 € ; coût de chaque résultat supplémentaire : 2 700 / 3 = **900 €**.
3. **A est plus efficace** : elle fait atteindre l'objectif à une plus grande part des participants (40 % contre 15 %) et à plus de personnes (12 contre 9). **B est plus efficiente** sur cet indicateur : chaque personne ayant atteint l'objectif coûte 166,67 € contre 350 €.
4. La **durabilité** des effets (B agit surtout pendant la distribution, A donne des compétences durables) ; les **autres effets** (savoir-faire, entraide) ; le **public touché** (qui sont les participants, équité) ; la **satisfaction** et l'acceptabilité ; la possibilité de **combiner** les deux actions ; les moyens disponibles.
5. Exemple : reconduire l'**action A**, qui produit des compétences durables et du lien social, en intégrant une distribution de bons d'achat ciblée sur les participants qui ont le moins de ressources (combinaison qui agit à la fois sur les compétences et sur l'accès) ; mesurer le maintien à trois mois pour vérifier que l'investissement supplémentaire se justifie. Une autre décision est acceptable si elle est argumentée (par exemple B, si l'objectif prioritaire est de toucher beaucoup de familles avec un budget faible).

Corrigé – Exercice 9.24

1. Participants : 12 / 40 = **30,0 %** avant ; 26 / 40 = **65,0 %** après ; **+ 35,0 points**. Commune voisine : 11 / 38 = **28,9 %** avant ; 14 / 38 = **36,8 %** après ; **+ 7,9 points**.
2. Différence des évolutions : 35,0 − 7,9 = **27,1 points**. Elle estime la part de l'évolution qui n'est pas expliquée par les facteurs communs aux deux communes (saison, campagne nationale, vieillissement) : c'est une estimation de l'effet propre des ateliers, si les groupes sont comparables.
3. RR = (26 / 40) / (14 / 38) = 0,650 / 0,368 = **1,76**. Erreur type : $\sqrt{(1/26 - 1/40 + 1/14 - 1/38)} = \sqrt{(0,0385 - 0,0250 + 0,0714 - 0,0263)} = \sqrt{0,0586} = 0,242$. IC à 95 % : $\exp(\ln 1,76 \pm 1,96 \times 0,242) = \exp(0,568 \pm 0,474)$, soit **[1,10 ; 2,84]**. L'intervalle ne contient pas 1 : en fin de projet, les participants ont significativement plus souvent un produit laitier au dîner que les retraités de la commune voisine (1,76 fois plus).
4. Des groupes **semblables au départ** (âge, sexe, revenus, isolement, état de santé, part de « oui » avant : ici

30,0 % et 28,9 %, très proches) ; des **mesures identiques** (mêmes questions, mêmes dates, même mode de passation) ; l'**absence d'autre action** importante dans l'une des communes pendant la période. On peut ajouter : des personnes recrutées de la même façon (volontaires dans les deux cas).

5. En fin de projet, la différence peut venir d'une **différence de départ** entre les groupes : si les participants avaient déjà de meilleures habitudes, une comparaison de fin de projet surestimerait l'effet. Comparer les **évolutions** neutralise la situation de départ et les facteurs communs. Ici les départs sont proches, ce qui renforce la conclusion.

Partie 5 – Interpréter et juger

Objectifs – Objectifs de la partie

- Interpréter un résultat en quatre temps : constater, comparer, expliquer, nuancer.
- Repérer les biais et les limites d'une évaluation, et proposer une correction.
- Reconnaître une conclusion abusive et la reformuler honnêtement.
- Juger un programme avec le modèle RE-AIM.
- Évaluer l'équité d'une action entre sous-groupes.
- Repérer les effets inattendus et les effets indésirables d'une action.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Interpréter, c'est : **constater** (le chiffre et l'effectif), **comparer** (à la cible, à la situation de départ, à un autre groupe), **expliquer** (les facteurs qui peuvent rendre compte du résultat), **nuancer** (les limites, les biais, ce que l'on ne peut pas affirmer).
- Les principaux biais : sélection (volontaires plus motivés), attrition (perdus de vue), désirabilité sociale (on répond ce qui fait plaisir), mémoire, effet de l'évaluateur, effet Hawthorne (on change parce qu'on est observé), saisonnalité, changement d'outil de mesure entre avant et après.
- Un avant / après sans groupe de comparaison montre une **évolution**, pas un **effet** démontré de l'action.
- RE-AIM : Portée (Reach), Efficacité, Adoption, Mise en œuvre (Implementation), Maintien.
- Une action est **équitable** si elle touche et réussit au moins autant chez les personnes les plus défavorisées : on compare couverture et résultats par sous-groupe (universalisme proportionné).

Exercice 9.25 – Interpréter un résultat en quatre temps (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de quartier (structure fictive) a proposé un cycle de 6 ateliers « Des légumes pour les petits » à 22 parents d'enfants de 1 à 3 ans. L'objectif spécifique était : « En fin de cycle, au moins 60 % des parents proposent un légume au repas du soir au moins 5 jours sur 7. » Pendant le cycle, chaque famille a aussi reçu un panier de légumes gratuit par semaine, offert par une épicerie solidaire. Le questionnaire final a été rempli par 18 parents, qui avaient aussi répondu au premier questionnaire.

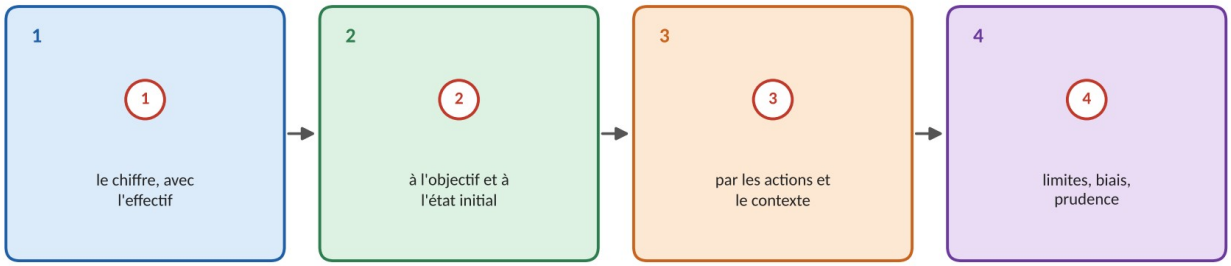


Figure 9.7 – Document 1 – Les quatre temps de l'interprétation (schéma à légender)

Document 2 – Réponses appariées des 18 parents (données fictives)

	« Oui » après	« Non » après	Total
« Oui » avant	6	1	7
« Non » avant	7	4	11
Total	13	5	18

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Constater : calculez les pourcentages avant et après et l'évolution en points. (2 pts)
3. Comparer : calculez le taux d'atteinte de l'objectif et le test de McNemar. (3 pts)
4. Expliquer : proposez deux facteurs qui peuvent rendre compte de l'évolution. (2 pts)
5. Nuancer : citez trois limites, puis rédigez une conclusion de trois phrases pour le bilan. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.26 – Biais et limites d'une évaluation (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous relisez le bilan d'un projet « Bien manger au travail » mené dans une entreprise de transport (entreprise fictive) de janvier à juin. Le chargé de projet, qui a aussi animé toutes les séances, a rédigé la partie évaluation. Votre tutrice vous demande de repérer les faiblesses de la méthode.

Document 1 – Extraits de la partie « Évaluation » du bilan

a) « Les 25 salariés inscrits étaient tous volontaires ; ils ont répondu au questionnaire en janvier. »

b) « En juin, seuls 14 salariés ont répondu au questionnaire final ; nous avons comparé la moyenne des 25 réponses de janvier à celle des 14 réponses de juin. »

c) « J'ai moi-même fait passer les questionnaires, en face à face, à la fin de chaque séance. »

d) « En janvier, nous demandions combien de fruits avaient été mangés le mois précédent ; en juin, nous avons demandé combien de fruits avaient été mangés la veille. »

e) « La consommation de fruits a nettement augmenté entre janvier et juin. »

f) « Pendant le projet, une enquête de la médecine du travail a été annoncée ; les salariés savaient qu'ils seraient observés à la cafétéria. »

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque extrait a) à f), nommez le biais ou la limite. (6 pts)
2. Pour chaque extrait, proposez une correction réaliste pour la prochaine édition. (4,5 pts)
3. Expliquez pourquoi l'extrait b) peut faire croire à une amélioration qui n'existe pas. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.27 – Les conclusions abusives (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse et rédaction · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service de soins à domicile (structure fictive) a mené un projet « Le goûter qui compte » auprès de personnes âgées vivant seules. Le compte rendu destiné au conseil d'administration contient plusieurs phrases trop affirmatives.

Document 1 – Six phrases du compte rendu

a) « Grâce à notre projet, la dénutrition a disparu chez nos bénéficiaires. » (Aucune mesure de poids ni de dépistage n'a été faite.)

b) « La part des bénéficiaires qui prennent un goûter est passée de 20 % à 30 % : elle a augmenté de 10 %. »

c) « La part des bénéficiaires qui mangent un produit laitier au goûter est passée de 3 sur 12 au départ à 6 sur 10 à la fin, soit une progression spectaculaire. » (Deux bénéficiaires ont quitté le projet.)

d) « 100 % des participants sont satisfaits. » (5 répondants sur 31 bénéficiaires.)

e) « Les personnes âgées de tout le département devraient bénéficier de ce projet, qui a prouvé son efficacité. »

f) « Les bénéficiaires qui ont reçu le plus de visites ont le plus progressé : ce sont donc les visites qui expliquent les progrès. »

À vous de jouer – Questions

1. Pour la phrase b), calculez l'évolution en points et en pourcentage, puis corrigez la phrase. (2 pts)
2. Pour la phrase c), calculez les deux pourcentages et expliquez pourquoi la comparaison n'est pas correcte. (2 pts)
3. Pour les phrases a), d), e) et f), expliquez en une phrase ce qui est abusif. (4 pts)
4. Réécrivez de façon honnête deux des phrases a), d), e) ou f). (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.28 – Juger un programme avec RE-AIM (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un département (programme fictif) a proposé « Goûter malin » aux 40 accueils de loisirs de son territoire : des menus de goûters équilibrés, une formation des animateurs et un livret pour les familles. Les 40 accueils reçoivent au total 3 200 enfants. Vous participez au bilan à 6 mois avec la diététicienne du département.

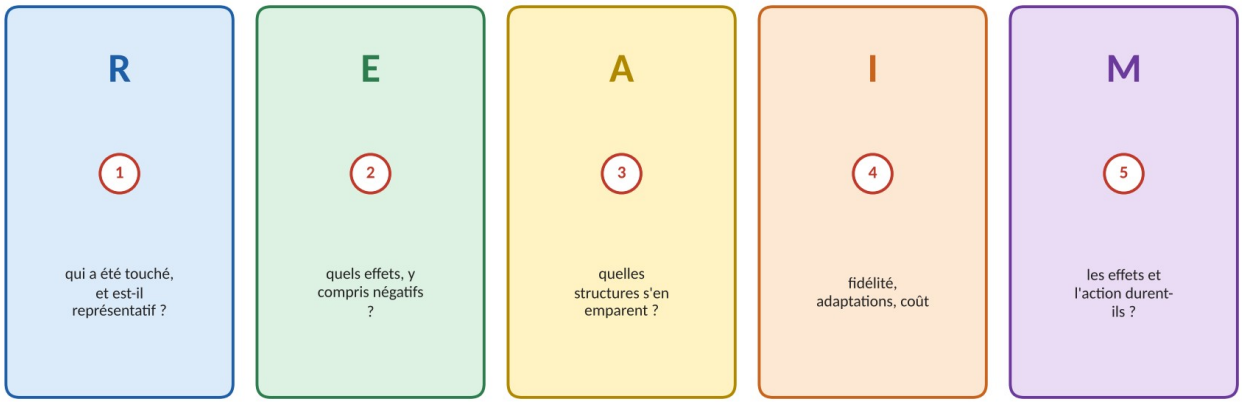


Figure 9.8 – Document 1 – Les cinq dimensions du modèle RE-AIM (schéma à légender)

Document 2 – Données du bilan (données fictives)

- 14 accueils sur 40 ont signé la charte « Goûter malin ».
- Ces 14 accueils reçoivent 1 120 enfants ; 868 enfants ont pris au moins 3 goûters « Goûter malin ».
- Observation de 6 accueils : la part des goûters qui contiennent un fruit est passée de 31 % à 58 %.
- 9 accueils sur 14 ont servi au moins 80 % des goûters prévus par les menus.
- Six mois après la fin de l'accompagnement, 8 accueils sur 14 utilisent encore les menus.
- Les 26 accueils qui n'ont pas signé évoquent surtout le manque de temps des animateurs et le coût des fruits.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)

2. Calculez un indicateur pour chacune des cinq dimensions. (5 pts)

3. Calculez la part de l'ensemble des 3 200 enfants touchés. Que montre ce chiffre ? (2 pts)

4. Indiquez la dimension la plus faible et justifiez. (2 pts)

5. Proposez deux améliorations ciblées sur cette dimension. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.29 – Évaluer l'équité d'une action (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une ville moyenne (ville fictive) a lancé un programme « Cuisine en famille » destiné aux 600 familles qui ont un enfant scolarisé en CP. 240 de ces familles habitent le quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). L'objectif spécifique était : « En fin de programme, les familles participantes préparent au moins trois repas « faits maison » par semaine. »

Document 1 – Participation et résultats par sous-groupe (données fictives)

Sous-groupe	Familles du public cible	Familles participantes	Familles ayant atteint l'objectif
Quartier prioritaire	240	18	8
Reste de la ville	360	42	27
Total	600	60	35

Les ateliers avaient lieu le mercredi à 14 h, au centre social du centre-ville, et l'inscription se faisait en ligne.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de couverture global et par sous-groupe. (2 pts)
2. Comparez la part des familles du QPV dans le public cible et parmi les participants. (2 pts)
3. Calculez la part de familles ayant atteint l'objectif dans chaque sous-groupe, et le rapport entre les deux. (3 pts)
4. Concluez sur l'équité du programme et proposez trois explications à partir du document. (3 pts)
5. Proposez trois ajustements selon le principe de l'universalisme proportionné, et un indicateur d'équité chiffré pour l'an prochain. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.30 – Effets inattendus et effets indésirables (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un lycée professionnel (établissement fictif) a retiré le cola sucré de son distributeur en janvier, dans le cadre d'un projet « Moins de sucre en 2027 ». Le bilan de mars présente les ventes d'un mois type avant et après le retrait. Les autres boissons sont restées au même prix.

Document 1 – Ventes mensuelles du distributeur (données fictives) et teneurs en sucres (table Ciqual 2025, ANSES, 19 novembre 2025, valeurs pour 100 g)

Boisson (code Ciqual 2025)	Format	Sucres (g pour 100 g)	Ventes avant	Ventes après
Cola, sucré (18018)	33 cl	10	420	0
Nectar multifruit, base pomme, standard (2009)	25 cl	10	150	310
Boisson énergisante, sucrée (18352)	25 cl	10,2	40	230
Eau minérale, plate	50 cl	0	260	300

On admet que 1 cl de boisson pèse 10 g.

Document 2 – Observations recueillies lors du bilan

a) Plusieurs élèves disent acheter des canettes de cola au supermarché voisin, à la pause de midi.

b) Le CPE signale des élèves agités en cours après la pause.

c) Des élèves ont demandé que le lycée installe une fontaine à eau fraîche.

d) Deux élèves ont été moqués par leurs camarades parce qu'ils avaient « encore leur soda ».

e) Le foyer des élèves a créé un « bar à eaux aromatisées » maison, très fréquenté.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la quantité de sucres apportée par une unité de chaque boisson sucrée. (1,5 pt)
2. Calculez la quantité totale de sucres vendue par mois avant et après le retrait, et l'évolution en pourcentage. (3 pts)
3. Calculez l'évolution des ventes de boisson énergisante. Expliquez pourquoi cet effet de report est indésirable chez des adolescents. (3 pts)
4. Classez les observations a) à e) en effets positifs ou négatifs, et inattendus ou attendus. (2,5 pts)
5. Proposez trois mesures pour limiter les effets indésirables, et deux façons de repérer les effets inattendus dès le début d'un projet. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 9.25

1. 1 = **Constater** ; 2 = **Comparer** ; 3 = **Expliquer** ; 4 = **Nuancer**.
2. Avant : 7 / 18 = **38,9 %** ; après : 13 / 18 = **72,2 %** ; évolution : **+ 33,3 points** (6 parents de plus).
3. Taux d'atteinte : 72,2 / 60 × 100 = **120,4 %** : la cible est dépassée. McNemar : b = 1, c = 7 ; $\chi^2 = (|1 - 7| - 1)^2 / (1 + 7) = 25 / 8 =$ **3,13**, inférieur à 3,84 : l'évolution n'est **pas significative** au risque de 5 %. De plus, b + c = 8 est inférieur à 10 : le test est peu fiable avec si peu de changements.
4. Exemples : les ateliers (recettes simples, dégustation par les enfants, échanges entre parents) ; le **panier de légumes gratuit**, qui lève le frein du coût et peut expliquer à lui seul une partie de l'évolution ; la saison (légumes plus variés au printemps).
5. Limites : petit effectif (18 parents) et test non significatif ; réponses **déclaratives** (désirabilité sociale) ; **4 parents perdus de vue** sur 22 (18 / 22 = 81,8 % de répondants), peut-être les moins concernés ; pas de groupe de comparaison ; deux actions mêlées (ateliers et panier), dont on ne peut pas séparer les effets ; pas de mesure du maintien. Conclusion possible : « En fin de cycle, 13 parents sur 18 (72,2 %) proposent un légume au repas du soir au moins 5 jours sur 7, contre 7 sur 18 au départ : la cible de 60 % est dépassée. Cette évolution n'est pas statistiquement significative compte tenu du petit nombre de parents, et elle peut venir autant du panier gratuit que des ateliers. Une mesure à trois mois, après l'arrêt des paniers, permettra de vérifier si le changement se maintient. »

Corrigé – Exercice 9.26

Extrait	Biais ou limite	Correction proposée
a)	**Biais de sélection** : les volontaires sont plus motivés que l'ensemble des salariés ; les résultats ne sont pas généralisables.	Le dire dans le bilan ; comparer le profil des inscrits à celui de l'ensemble des salariés ; ajouter un groupe de comparaison si possible.
b)	**Attrition** (11 perdus de vue) et comparaison de **groupes différents** (25 contre 14).	Comparer seulement les 14 réponses **appariées** (avant et après des mêmes personnes) ; relancer les absents ; décrire les perdus de vue.
c)	**Effet de l'évaluateur** et **désirabilité sociale** : on répond ce qui fait plaisir à l'animateur.	Questionnaire anonyme, rempli seul, recueilli par une autre personne (urne, formulaire en ligne).
d)	**Changement d'outil de mesure** (un mois contre la veille) ; **biais de mémoire** sur un mois.	Garder exactement la même question aux deux temps, de préférence sur une période courte (les 7 derniers jours).
e)	**Conclusion vague** sans chiffre ni effectif ; évolution présentée comme un effet.	Donner les effectifs et les pourcentages, le test, et parler d'évolution et non d'effet démontré.
f)	**Effet Hawthorne** : les salariés changent parce qu'ils se savent observés.	Le signaler dans les limites ; refaire une mesure à distance, hors période d'observation.

3. Si les 11 salariés qui n'ont pas répondu en juin étaient les moins engagés (ceux qui mangeaient le moins de fruits), la moyenne de juin porte sur les plus motivés : elle augmente même si **personne n'a changé**. C'est un effet de composition du groupe, et non une amélioration.

Corrigé – Exercice 9.27

1. Évolution : 30 − 20 = **+ 10 points** ; en pourcentage : (30 − 20) / 20 × 100 = **+ 50 %**. Phrase corrigée : « La part des bénéficiaires qui prennent un goûter est passée de 20 % à 30 %, soit une hausse de 10 points (la part a été multipliée par 1,5). »
2. Avant : 3 / 12 = **25,0 %** ; après : 6 / 10 = **60,0 %**. Les deux pourcentages ne portent pas sur les **mêmes**

personnes : les deux bénéficiaires partis étaient peut-être ceux qui ne prenaient pas de produit laitier. Il faut comparer les 10 bénéficiaires présents aux deux temps (réponses appariées) et donner les effectifs.

3. a) Le projet n'a **mesuré** ni le poids ni la dénutrition : on ne peut rien affirmer sur ce point (confusion entre résultat intermédiaire et impact). d) 5 répondants sur 31 (16 %) : on ne peut pas généraliser, et les satisfaits répondent plus volontiers. e) Généralisation abusive : un petit groupe local, sans groupe de comparaison, ne « prouve » pas une efficacité transposable à tout le département. f) **Corrélation n'est pas causalité** : les bénéficiaires les plus visités sont peut-être aussi les plus autonomes ou les plus motivés.

4. Exemples : a) « Le projet n'a pas mesuré l'état nutritionnel ; il a augmenté la part des bénéficiaires qui prennent un goûter, ce qui peut contribuer à prévenir la dénutrition. » d) « Les 5 bénéficiaires qui ont rendu le questionnaire de satisfaction (sur 31) se déclarent satisfaits ; ce résultat ne peut pas être étendu à l'ensemble. » e) « Le projet a donné des résultats encourageants sur un petit groupe ; il pourrait être expérimenté dans un autre secteur avec une évaluation comparative avant d'être étendu. » f) « Les bénéficiaires qui ont reçu le plus de visites ont davantage progressé ; ce lien peut s'expliquer par les visites, mais aussi par d'autres différences entre les bénéficiaires. »

Corrigé – Exercice 9.28

1. 1 = **Portée** (Reach) ; 2 = **Efficacité** ; 3 = **Adoption** ; 4 = **Mise en œuvre** ; 5 = **Maintien**.

2. Portée : 868 / 1 120 = **77,5 %** des enfants des accueils signataires. Efficacité : part des goûters avec un fruit **31 % → 58 %**, soit **+ 27 points** (sur 6 accueils observés). Adoption : 14 / 40 = **35,0 %** des accueils. Mise en œuvre : 9 / 14 = **64,3 %** des accueils ont servi au moins 80 % des goûters prévus. Maintien : 8 / 14 = **57,1 %** des accueils utilisent encore les menus à 6 mois.

3. 868 / 3 200 = **27,1 %** des enfants du territoire. Malgré une bonne portée dans les accueils signataires et une efficacité réelle, le programme ne touche qu'un enfant sur quatre environ : l'impact sur la population dépend de toutes les dimensions à la fois.

4. L'**adoption** est la plus faible (35,0 %) : près de deux accueils sur trois n'ont pas signé, pour des raisons de temps et de coût. C'est elle qui limite le plus le nombre d'enfants touchés.

5. Exemples : proposer des menus « prêts à l'emploi » qui demandent moins de préparation (fruits faciles à servir, liste d'achats fournie) ; négocier un groupement d'achat de fruits ou une aide financière par goûter ; faire témoigner les accueils signataires auprès des autres ; former les directeurs en même temps que les animateurs.

Corrigé – Exercice 9.29

1. Global : 60 / 600 = **10,0 %** ; QPV : 18 / 240 = **7,5 %** ; reste de la ville : 42 / 360 = **11,7 %**.

2. Les familles du QPV représentent 240 / 600 = **40,0 %** du public cible mais seulement 18 / 60 = **30,0 %** des participants : elles sont **sous-représentées**.

3. QPV : 8 / 18 = **44,4 %** ; reste de la ville : 27 / 42 = **64,3 %** ; rapport : 64,3 / 44,4 = **1,45** : les familles hors QPV atteignent l'objectif 1,45 fois plus souvent.

4. Le programme n'est **pas équitable** : il touche moins et réussit moins chez les familles du QPV, qui en ont souvent le plus besoin ; il risque d'**aggraver les inégalités sociales de santé**. Explications tirées du document : ateliers le **mercredi à 14 h** (incompatible avec certains horaires de travail ou la garde des autres enfants) ; lieu au **centre-ville**, loin du quartier ; inscription **en ligne** (fracture numérique, barrière de la langue). On peut ajouter des recettes peut-être éloignées des habitudes et du budget de ces familles.

5. Exemples : organiser une partie des ateliers **dans le QPV** (centre social, école), avec des horaires variés (samedi, fin de journée) ; inscription aussi **en face à face**, par l'école, le centre social ou des parents relais ; adapter les recettes au budget et aux cultures culinaires, fournir les ingrédients ; prévoir une garde des jeunes enfants. Indicateur d'équité : « Taux de couverture des familles du QPV au moins égal à celui du reste de la ville, soit au moins 24 familles sur 240 (10 %) », ou « part des familles du QPV parmi les

participants au moins égale à 40 % ».

Corrigé – Exercice 9.30

1. Cola : 330 g × 10 / 100 = **33,0 g** par canette ; nectar : 250 g × 10 / 100 = **25,0 g** par brique ; boisson énergisante : 250 g × 10,2 / 100 = **25,5 g** par canette.

2. Avant : 420 × 33,0 + 150 × 25,0 + 40 × 25,5 = 13 860 + 3 750 + 1 020 = **18 630 g**, soit 18,6 kg. Après : 310 × 25,0 + 230 × 25,5 = 7 750 + 5 865 = **13 615 g**, soit 13,6 kg. Évolution : (13 615 − 18 630) / 18 630 × 100 = **−26,9 %**. La baisse est réelle mais bien plus faible que ce que le retrait du cola laissait espérer.

3. Ventes de boisson énergisante : 40 → 230, soit (230 − 40) / 40 × 100 = **+ 475 %** (5,75 fois plus). Effet indésirable : ces boissons apportent autant de sucres que le cola et, en plus, de la **caféine** (et souvent de la taurine) ; chez l'adolescent, une consommation importante peut entraîner agitation, troubles du sommeil, palpitations ; l'ANSES recommande d'en éviter ou d'en limiter la consommation, en particulier chez les enfants et les adolescents (avis sur les boissons dites énergisantes, octobre 2013). L'observation b) peut en être un signe.

4. a) **Négatif, inattendu** (report des achats hors du lycée, la consommation de cola n'a peut-être pas baissé) ; b) **négatif, inattendu** (possible lien avec les boissons énergisantes, à vérifier) ; c) **positif, inattendu** (demande d'eau, appropriation du projet) ; d) **négatif, inattendu** (stigmatisation des élèves) ; e) **positif, inattendu** (initiative des élèves, alternative appréciée). Seule la hausse des ventes d'eau (260 → 300) était un effet attendu.

5. Mesures : retirer aussi la boisson énergisante ou la remplacer par une eau aromatisée sans sucres ; installer une **fontaine à eau fraîche** et soutenir le bar du foyer ; accompagner le retrait d'une **action éducative** (pourquoi ce choix, sans culpabiliser) et rappeler à tous le respect des choix de chacun. Repérer les effets inattendus : poser des **questions ouvertes** (« Qu'est-ce qui a changé pour vous ? ») aux élèves et aux personnels ; tenir un **journal de bord** ; suivre des indicateurs « d'alerte » (ventes de toutes les boissons, passages à l'infirmerie, achats à l'extérieur) ; réunir un petit groupe d'élèves à mi-parcours.

Partie 6 – L'évaluation qualitative

Objectifs – Objectifs de la partie

- Choisir une méthode qualitative adaptée à la question et au public.
- Rédiger et corriger un guide d'entretien.
- Coder des verbatims, les regrouper en thèmes et en tirer des enseignements.
- Croiser des données qualitatives et quantitatives (triangulation).
- Évaluer sa propre animation.
- Organiser et interpréter une mesure à distance.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- L'évaluation qualitative répond aux questions **pourquoi** et **comment** : elle explique les chiffres, fait apparaître les freins, les leviers et les effets inattendus.
- Méthodes : entretien individuel semi-directif, entretien collectif (focus group), observation, photolangage, questions ouvertes, journal de bord, technique du « mur des avis ».
- Démarche : recueillir, transcrire, coder, regrouper en thèmes, interpréter. Un **verbatim** est une phrase rapportée mot pour mot, anonymisée.
- Une bonne question d'entretien est **ouverte**, **neutre** (elle ne suggère pas la réponse), **simple** et ne porte que sur une idée.
- Trianguler, c'est croiser plusieurs sources ou méthodes pour confirmer ou nuancer un résultat.
- Une mesure à distance (1 à 6 mois) vérifie le **maintien** des changements ; il faut décrire les personnes non jointes.

Exercice 9.31 – Choisir une méthode qualitative (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre communal d'action sociale (structure fictive) termine un cycle d'ateliers « Cuisiner avec le colis » pour les bénéficiaires de l'aide alimentaire. La responsable veut comprendre pourquoi certains bénéficiaires ont arrêté de venir et ce que les autres ont changé dans leur cuisine.

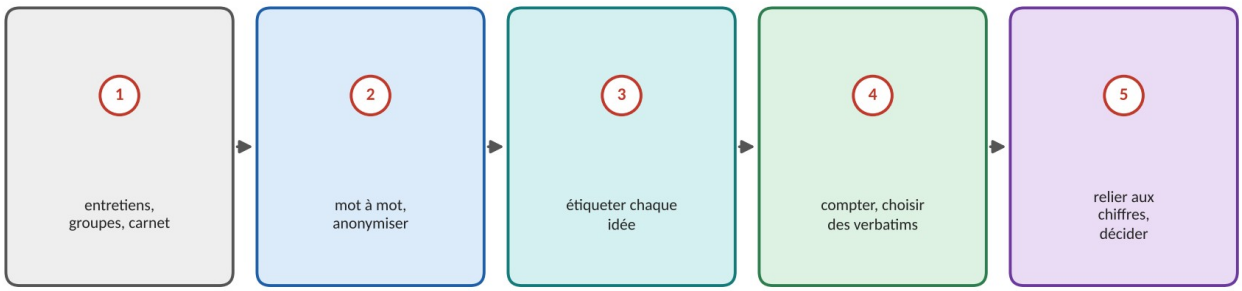


Figure 9.9 – Document 1 – Les étapes de l'analyse qualitative (schéma à légender)

Document 2 – Cinq besoins d'information

a) Comprendre en profondeur pourquoi trois personnes ont arrêté après deux ateliers.

b) Recueillir rapidement l'avis de tout le groupe à la fin du dernier atelier, y compris des personnes qui lisent difficilement le français.

c) Savoir comment les participants utilisent réellement les produits du colis à la maison.

d) Faire émerger les idées du groupe pour le prochain cycle, en faisant réagir les participants entre eux.

e) Vérifier que l'animatrice laisse la parole aux participants pendant la séance.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Pour chaque besoin a) à e), choisissez une méthode qualitative et justifiez. (5 pts)
3. Indiquez deux précautions éthiques à respecter avant un entretien. (1,5 pt)
4. Expliquez pourquoi une évaluation qualitative ne permet pas de dire « 40 % des participants pensent que… ». (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.32 – Le guide d'entretien (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse et rédaction · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un institut médico-éducatif (structure fictive), un projet « Mon assiette, mon choix » a permis à des adolescents de participer à l'élaboration des menus. Une stagiaire a préparé un guide d'entretien pour les éducateurs. Votre tutrice vous demande de le relire.

Document 1 – Le guide d'entretien proposé

1. Êtes-vous satisfait du projet ?
2. Ne pensez-vous pas que les jeunes mangent mieux depuis le projet ?
3. Combien de jeunes ont participé aux commissions menus, et comment les avez-vous choisis, et qu'en ont pensé les familles ?
4. Les jeunes ont-ils compris l'intérêt de l'équilibre alimentaire et du PNNS ?
5. Le projet vous a-t-il pris du temps ?
6. Avez-vous autre chose à ajouter ?

À vous de jouer – Questions

1. Pour chacune des questions 1 à 5, nommez le défaut. (5 pts)
2. Réécrivez les questions 1 à 5 en questions ouvertes, neutres et simples. (5 pts)
3. Proposez deux questions de relance. (1 pt)
4. Indiquez comment présenter l'entretien en introduction (trois éléments). (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.33 – Coder des verbatims (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une résidence étudiante (structure fictive) a proposé pendant un semestre des ateliers de cuisine du jeudi soir et un panier de légumes à 5 €. Lors du bilan, 16 étudiants ont répondu à la question ouverte : « Qu'est-ce que ces ateliers vous ont apporté, et qu'est-ce qui vous a gêné ? »

Document 1 – Les 16 verbatims (anonymisés)

V1 « On rigole bien, et j'ai rencontré des gens de mon étage. »

V2 « Le panier à 5 €, c'est ce qui m'a fait venir, sinon je mange des pâtes tous les soirs. »

V3 « Je n'avais jamais goûté de pois chiches, maintenant j'en achète. »

V4 « Entre les cours et mon petit boulot, je n'ai pas le temps de cuisiner le soir. »

V5 « Avec une seule plaque dans le studio, la recette du gratin, c'était impossible. »

V6 « Cuisiner ensemble, ça change de manger seul devant l'ordinateur. »

V7 « Le potimarron, je ne savais même pas que ça se mangeait ! »

V8 « Les recettes sont trop longues, il y a trop d'étapes. »

V9 « J'ai économisé sur mes courses ce mois-ci. »

V10 « Je viens surtout pour voir du monde, je suis arrivée de l'étranger en septembre. »

V11 « Sans four ni robot, je ne peux pas refaire la moitié des plats. »

V12 « C'est moins cher que le restaurant universitaire et c'est meilleur. »

V13 « J'ai appris à cuisiner des lentilles, je les mets dans mes salades. »

V14 « Le créneau du jeudi soir tombe pendant mes partiels, j'ai raté trois ateliers. »

V15 « J'aimerais des recettes en 15 minutes. »

V16 « On s'entraide maintenant pour faire les courses à plusieurs, ça revient moins cher. »

À vous de jouer – Questions

1. Codez les verbatims avec les six codes suivants (un verbatim peut recevoir deux codes) : convivialité, prix, découverte d'aliments, manque de temps, équipement insuffisant, recettes trop compliquées. (5 pts)
2. Comptez les verbatims par code, puis regroupez les codes en deux thèmes. (3 pts)
3. Choisissez deux verbatims à citer dans le bilan et justifiez votre choix. (2 pts)
4. Rédigez trois enseignements et trois ajustements pour le semestre suivant. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.34 – Croiser le qualitatif et le quantitatif (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD fictif) a lancé des « repas du monde » une fois par semaine pendant trois mois, pour donner envie de manger. Vous participez au bilan avec la diététicienne.

Document 1 – Résultats quantitatifs (données fictives)

- Questionnaire de satisfaction : 34 résidents satisfaits sur 40 répondants.
- Pesée des restes : 24 % des quantités servies avant le projet, 31 % les jours de « repas du monde ».
- Nombre moyen de résidents présents en salle à manger les jours de « repas du monde » : 52 sur 60, contre 47 sur 60 les autres jours.

Document 2 – Extraits de l'entretien collectif avec 8 résidents et 2 soignants

- « C'est joli, la décoration, la musique, on se croirait en voyage. » (résidente)
- « Le couscous était trop épicé pour moi, j'ai laissé la moitié. » (résident)
- « Les portions sont énormes ces jours-là, on n'arrive pas à finir. » (résidente)
- « Les morceaux de viande sont durs pour ceux qui ont un dentier. » (soignante)
- « Je n'ose pas dire que je n'aime pas, la cuisinière s'est donné tant de mal. » (résident)
- « On attend ce jour-là, on en parle toute la semaine. » (soignant)

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de satisfaction, l'évolution des restes en points et le taux de présence en salle les deux types de jours. (3 pts)
2. Repérez la contradiction entre les résultats quantitatifs. (2 pts)
3. Expliquez cette contradiction à l'aide du document 2. (3 pts)
4. Montrez que le questionnaire de satisfaction a sans doute surestimé l'appréciation des plats. (2 pts)
5. Rédigez une conclusion qui croise les deux sources et trois recommandations. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.35 – Évaluer son animation (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un centre de protection maternelle et infantile (structure fictive), une stagiaire anime un atelier de 60 minutes sur la diversification alimentaire pour 11 parents. Sa tutrice l'observe avec une grille et lui remet le relevé ci-dessous.

Document 1 – Relevé d'observation de la tutrice

- Temps de parole : stagiaire 38 min ; parents 14 min ; activités et silences 8 min.
- Questions posées par la stagiaire : 19, dont 4 ouvertes.
- Parents ayant pris la parole au moins une fois : 5 sur 11.
- Remarques : diaporama de 24 diapositives ; deux parents consultent leur téléphone après 30 minutes ; une maman pose une question sur le « fait maison » sans réponse claire ; dégustation de purées en fin de séance très appréciée.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part du temps de parole de chacun, la part de questions ouvertes et la part de parents qui ont parlé. (3 pts)

2. À partir de ces chiffres, rédigez deux points forts et trois points à améliorer. (3 pts)

3. Proposez trois changements concrets pour la prochaine séance. (3 pts)

4. Rédigez trois questions d'auto-évaluation que la stagiaire pourra se poser après chaque séance. (1,5 pt)

5. Pourquoi faut-il évaluer l'animation en plus des résultats chez les participants ? (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.36 – La mesure à distance (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une usine agroalimentaire (entreprise fictive) a proposé à 20 salariés de l'équipe de nuit des ateliers « Bien manger la nuit ». L'objectif était de remplacer le grignotage de la pause de 3 h par une collation prévue à l'avance. Trois mois après la fin des ateliers, l'infirmière du travail a rappelé les salariés par téléphone.

Document 1 – Résultats (données fictives)

- Fin des ateliers (T1) : 14 salariés sur 20 déclarent prendre une collation prévue à l'avance au moins 4 nuits sur 5.
- Trois mois après (T3) : 16 salariés ont été joints. Parmi eux, 12 avaient répondu « oui » à T1 et 4 « non ».
- À T3, 9 des 12 salariés qui répondaient « oui » à T1 répondent encore « oui » ; 1 des 4 salariés qui répondaient « non » à T1 répond « oui ».
- Les 4 salariés non joints : 2 ont quitté l'entreprise, 2 n'ont pas répondu à trois appels.
- Raisons citées par les salariés qui ont arrêté : « plus le temps de préparer », « le distributeur est plus pratique », « personne ne m'en reparle ».

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le résultat à T1, le taux de salariés joints à T3 et le résultat à T3 parmi les salariés joints. (3 pts)

2. Calculez le taux de maintien chez les salariés qui avaient changé. (2 pts)

3. Calculez le résultat à T3 sur les 20 salariés dans une hypothèse pessimiste et dans une hypothèse optimiste. Expliquez l'intérêt de ce calcul. (4 pts)

4. Interprétez les raisons d'arrêt et proposez trois actions pour favoriser le maintien. (3 pts)

5. Indiquez deux précautions pour qu'une mesure par téléphone soit fiable. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 9.31

1. 1 = **Recueillir** ; 2 = **Transcrire** ; 3 = **Coder** ; 4 = **Regrouper en thèmes** ; 5 = **Interpréter**.
2. a) **Entretien individuel semi-directif** (par téléphone ou à domicile) : il permet d'aborder des raisons personnelles (honte, santé, horaires) sans le regard du groupe. b) **Mur des avis** avec pictogrammes ou **photolangage** (gommettes sur des visages, photos à choisir) : rapide, collectif, sans lecture. c) **Observation** ou visite à domicile acceptée, ou **journal de bord** photo des repas : on voit les pratiques réelles et non seulement les déclarations. d) **Entretien collectif** (focus group) : les participants réagissent aux idées des autres. e) **Observation** de la séance avec une grille (temps de parole, questions posées).
3. Exemples : informer la personne de l'objectif et de l'usage des réponses ; recueillir son **accord** (y compris pour un enregistrement) ; garantir l'**anonymat** et la confidentialité ; laisser la liberté de ne pas répondre ou d'arrêter.
4. Les participants interrogés sont peu nombreux et choisis pour la diversité de leurs points de vue, et non tirés au sort : les fréquences ne sont **pas représentatives**. Le qualitatif repère des idées et des mécanismes, il ne mesure pas leur fréquence.

Corrigé – Exercice 9.32

1. Q1 : question **fermée** (oui ou non), qui n'apprend rien sur le contenu. Q2 : question **orientée** (elle suggère la réponse attendue). Q3 : question **multiple** (trois questions en une), qui en plus porte sur des chiffres connus par ailleurs. Q4 : question **fermée** et **jargonneuse** (« PNNS ») qui met l'éducateur en position de juger. Q5 : question **fermée**, qui ne dit pas quelles tâches ont pris du temps.
2. Exemples : Q1 « Que retenez-vous de ce projet ? » ou « Comment s'est passé le projet pour vous ? » ; Q2 « Qu'avez-vous observé dans les repas des jeunes depuis le début du projet ? » ; Q3 « Comment se sont déroulées les commissions menus ? » (les effectifs se recueillent dans les documents) ; Q4 « Qu'est-ce que les jeunes disent ou font qui montre ce qu'ils ont retenu sur l'alimentation ? » ; Q5 « Comment le projet s'est-il intégré dans votre travail quotidien ? ».
3. Exemples : « Pouvez-vous me donner un exemple ? » ; « Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? » ; « Et ensuite, que s'est-il passé ? ».
4. Se présenter et présenter l'**objectif** de l'entretien ; annoncer la **durée** ; garantir la **confidentialité** et demander l'accord pour prendre des notes ou enregistrer ; préciser qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.

Corrigé – Exercice 9.33

1. Codage proposé :

Code	Verbatims
Convivialité	V1, V6, V10, V16
Prix	V2, V9, V12, V16
Découverte d'aliments	V3, V7, V13
Manque de temps	V4, V8, V14, V15
Équipement insuffisant	V5, V11
Recettes trop compliquées	V8, V15

2. Comptage : convivialité **4**, prix **4**, découverte **3**, manque de temps **4**, équipement **2**, recettes compliquées **2**, soit 19 codes pour 16 verbatims. Thème « **Leviers** » (convivialité, prix, découverte) : 11 codes, 10 verbatims. Thème « **Freins** » (temps, équipement, recettes) : 8 codes, 6 verbatims (V4, V5, V8, V11, V14, V15). Ces nombres décrivent ce groupe : ils ne sont pas des pourcentages généralisables.

3. Exemples : V10, qui montre un effet inattendu sur l'isolement des étudiants arrivés de l'étranger ; V11, qui montre un frein concret et facile à corriger. On choisit des verbatims **parlants**, qui illustrent un thème, en équilibrant points positifs et négatifs.

4. Enseignements : les ateliers rompent l'**isolement** et créent de l'entraide ; le **prix** du panier est un levier fort ; les recettes sont **inadaptées** à l'équipement des studios et au temps des étudiants. Ajustements : recettes en 15 minutes avec **une seule plaque** ou un four à micro-ondes ; un **second créneau** et un calendrier qui évite les partiels ; garder le panier à 5 € et proposer des courses groupées ; un temps convivial (repas partagé) à chaque atelier.

Corrigé – Exercice 9.34

1. Satisfaction : 34 / 40 = **85,0 %** ; restes : 24 % → 31 %, soit **+ 7 points** ; présence en salle : 52 / 60 = **86,7 %** les jours de « repas du monde », 47 / 60 = **78,3 %** les autres jours.

2. Les résidents se disent **très satisfaits** et viennent plus nombreux, mais ils laissent **davantage** de nourriture : ils mangent probablement moins, ce qui va contre l'objectif.

3. Le document 2 sépare deux choses : l'**ambiance** est très appréciée (décoration, musique, attente du jour), ce qui explique la satisfaction et la présence ; les **plats** posent problème : trop épicés, portions trop grosses, textures difficiles à mâcher pour certains résidents, ce qui explique les restes.

4. Un résident n'ose pas dire qu'il n'aime pas (**désirabilité sociale**) ; le questionnaire mélange sans doute l'ambiance et les plats dans une seule question de satisfaction. Les restes, mesure objective, contredisent l'appréciation déclarée des plats.

5. Exemple : « Les "repas du monde" sont un moment attendu, qui attire plus de résidents en salle à manger (86,7 % contre 78,3 %) et qui les satisfait (85,0 %). En revanche, les restes augmentent de 7 points : les entretiens montrent que les épices, la taille des portions et la texture de la viande freinent la consommation. » Recommandations : garder l'ambiance et adapter les recettes (épices servies à part, viandes mijotées ou hachées, textures adaptées) ; ajuster les portions et proposer un supplément à la demande ; dans le questionnaire, séparer les questions sur l'ambiance et sur chaque plat, et associer la cuisinière à des dégustations avec quelques résidents.

Corrigé – Exercice 9.35

1. Temps de parole : stagiaire 38 / 60 = **63,3 %** ; parents 14 / 60 = **23,3 %** ; activités et silences 8 / 60 = **13,3 %**. Questions ouvertes : 4 / 19 = **21,1 %**. Parents ayant parlé : 5 / 11 = **45,5 %**.

2. Points forts : la stagiaire pose beaucoup de questions (19) ; la **dégustation** est très appréciée. Points à améliorer : elle parle près des deux tiers du temps (atelier trop **magistral**, diaporama trop long) ; les questions sont surtout **fermées** ; plus de la moitié des parents ne se sont pas exprimés ; une question n'a pas reçu de réponse claire ; l'attention baisse après 30 minutes.

3. Exemples : commencer par un tour de table (« Où en êtes-vous de la diversification ? ») et partir des questions des parents ; réduire le diaporama à 6 diapositives et ajouter une activité en petits groupes (classer des aliments par âge d'introduction) ; avancer la dégustation au milieu de la séance ; préparer des réponses aux questions fréquentes (fait maison, petits pots).

4. Exemples : « Qui a parlé, et combien de temps ? » ; « Quelles questions des parents sont restées sans réponse ? » ; « À quel moment l'attention a-t-elle baissé, et pourquoi ? » ; « Qu'est-ce que je referais et qu'est-ce que je changerais ? ».

5. Les résultats chez les participants dépendent de la **qualité de l'animation** : si un objectif n'est pas atteint, l'évaluation du processus aide à savoir si c'est l'action qui est inadaptée ou sa mise en œuvre. Elle permet aussi à l'animateur de progresser.

Corrigé – Exercice 9.36

1. T1 : 14 / 20 = **70,0 %**. Salariés joints : 16 / 20 = **80,0 %**. T3 parmi les joints : (9 + 1) / 16 = 10 / 16 = **62,5 %**.

2. Maintien : 9 / 12 = **75,0 %** des salariés qui avaient changé et qui ont été joints ont gardé la nouvelle habitude ; 3 sont revenus en arrière.

3. Les 4 non joints comptaient 14 − 12 = 2 « oui » et 4 − 2 = 2 « non » à T1. Hypothèse **pessimiste** (aucun non-joint n'a la collation) : 10 / 20 = **50,0 %**. Hypothèse **optimiste** (tous l'ont) : 14 / 20 = **70,0 %**. Le vrai résultat se situe entre 50 % et 70 % : ce calcul montre l'**incertitude** due aux personnes perdues de vue et évite de présenter 62,5 % comme le résultat de tout le groupe.

4. Les arrêts viennent du **manque de temps**, de la **concurrence du distributeur** (plus facile) et de l'**absence de suivi**. Actions : proposer des collations sans préparation (fruit, laitage, pain et fromage) et des idées à préparer en 5 minutes ; améliorer l'offre du distributeur (fruits, produits laitiers, eau) avec l'entreprise ; prévoir une **relance** (message, rappel en réunion d'équipe, atelier de rappel à 2 mois) et un relais dans l'équipe de nuit.

5. Poser **exactement la même question** qu'à T1 ; appeler à un moment adapté (avant la prise de poste, pas en plein sommeil) ; faire appeler par une personne autre que l'animatrice ou rappeler l'anonymat, pour limiter la désirabilité sociale ; noter les non-réponses et leurs raisons.

Partie 7 – Valoriser et rendre compte

Objectifs – Objectifs de la partie

- Adapter la valorisation à chaque public.
- Remplir le compte rendu financier d'une subvention (Cerfa n° 15059) : écarts, solde et reversement.
- Rédiger une note de synthèse destinée à des élus.
- Construire un poster de présentation du projet.
- Restituer les résultats aux participants en respectant l'éthique.
- Construire et repérer un graphique honnête.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Valoriser, c'est faire connaître le projet et ses résultats pour **rendre compte**, **remercier**, **convaincre** (financer, poursuivre) et **transférer** l'expérience.
- Une même évaluation donne plusieurs supports : restitution orale aux participants, bilan écrit aux partenaires, compte rendu financier au financeur, note aux élus, poster ou article pour les professionnels, communiqué pour le grand public.
- Le compte rendu financier (Cerfa n° 15059) compare le budget prévu et le budget réalisé, poste par poste, et explique les écarts importants. Si la subvention est plafonnée à un pourcentage des dépenses, elle est recalculée sur les dépenses réalisées.
- Une note aux élus tient sur **une page** : objet, contexte, trois résultats chiffrés, limites, proposition, décision demandée.
- Éthique de la restitution : anonymat, pas de résultat individuel identifiable, pas de petits effectifs isolés, accord pour les photos et les témoignages, langage non stigmatisant.
- Un graphique honnête : axe qui part de zéro pour des barres, effectifs indiqués, source et date, pas de 3D.

Exercice 9.37 – Valoriser auprès de chaque public (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de jardins partagés (association fictive) termine un projet « Du jardin à l'assiette » financé par la caisse d'allocations familiales et la ville. Le bilan est prêt. La présidente vous demande de prévoir la valorisation.

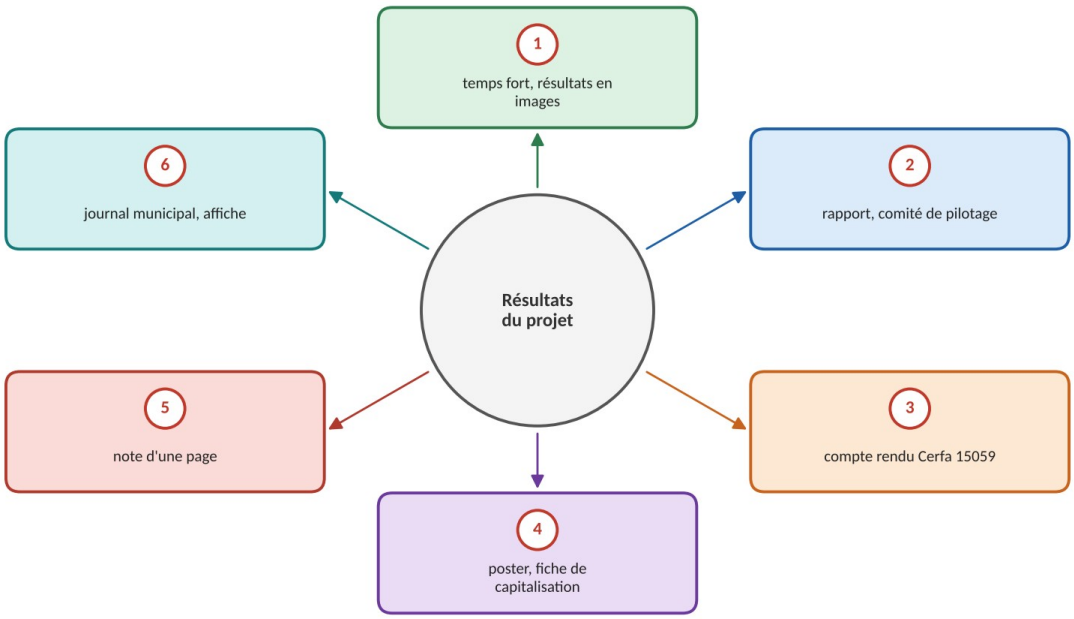


Figure 9.10 – Document 1 – Les publics de la valorisation (schéma à légender)

Document 2 – Huit supports possibles

a) Un compte rendu financier. b) Un repas partagé avec affichage des photos et des résultats. c) Un poster pour les journées d'une association de diététiciens. d) Un article dans le bulletin municipal. e) Une note d'une page avec une proposition chiffrée. f) Un bilan détaillé présenté en comité de pilotage. g) Une fiche de capitalisation déposée sur une base de partage d'expériences en santé publique. h) Une publication sur les réseaux sociaux de l'association.

À vous de jouer – Questions

1. **1.** Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. **2.** Associez chaque support a) à h) à un ou deux publics du document 1. (4 pts)
3. **3.** Pour deux publics de votre choix, indiquez ce qu'ils attendent en priorité du bilan. (2 pts)
4. **4.** Pourquoi faut-il restituer les résultats aux participants en premier ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.38 – Le compte rendu financier de la subvention (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – calcul et rédaction · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de prévention (association fictive) a reçu d'une fondation une subvention pour un projet d'ateliers dans trois collèges. La convention prévoit : « La subvention représente au plus 50 % des dépenses réalisées du projet. 70 % sont versés à la signature, le solde à la réception du compte rendu financier. Tout écart de plus de 15 % sur un poste doit être expliqué. » Deux ateliers ont été annulés à cause d'une grève des transports scolaires.

Document 1 – Budget prévu et budget réalisé (en euros, données fictives)

Poste de dépenses	Prévu	Réalisé
Achats de denrées	2 400	2 150
Petit matériel de cuisine	1 300	1 480
Intervenants (diététicienne, cuisinier)	3 600	2 700
Communication et impression	700	520
Déplacements	400	310
Frais de structure	800	640
Total	9 200	7 800

Subvention accordée : 50 % du budget prévu.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'écart en euros et en pourcentage pour chaque poste et pour le total, ainsi que le taux de réalisation du budget. (4 pts)
2. Indiquez les postes dont l'écart doit être expliqué, et rédigez une explication pour chacun. (4 pts)
3. Calculez la subvention accordée, la subvention due après réalisation, la somme déjà versée et le solde à verser. (3 pts)
4. Si la fondation avait versé toute la subvention à la signature, quelle somme l'association devrait-elle reverser ? (1 pt)
5. Pourquoi faut-il prévenir le financeur dès l'annulation des ateliers, et non au moment du bilan ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.39 – La note aux élus (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – calcul et rédaction · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une commune rurale (commune fictive) a financé à moitié un programme « Bien vieillir à table » pour ses habitants de 70 ans et plus. Le maire doit décider en conseil municipal s'il renouvelle le programme en 2028 et s'il l'étend à deux hameaux supplémentaires. Il vous demande une note d'une page.

Document 1 – Données du bilan (données fictives)

- Habitants de 70 ans et plus : 1 450. Participants : 96, répartis en 4 cycles de 6 ateliers dans 4 hameaux.
- Ateliers réalisés : 24 sur 24 prévus. Présences totales : 480.
- Questionnaire apparié (80 participants ont répondu avant et après) : consomment un produit laitier à chaque repas : 34 avant, 55 après ; mangent seuls tous les soirs : 41 avant, 30 après.
- Coût total : 14 400 €, dont 7 200 € payés par la commune.
- Satisfaction : 74 répondants sur 80 recommanderaient les ateliers à un proche.
- Coût estimé de l'extension à deux hameaux supplémentaires : 7 200 € de plus par an, dont 3 600 € pour la commune.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de couverture, le taux de présence, le taux de répondants, les deux résultats avant et après et le coût par participant (total et pour la commune). (5 pts)
2. Choisissez les trois chiffres à mettre en avant dans la note et justifiez votre choix. (2 pts)
3. Rédigez la note aux élus d'une page environ. (7 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.40 – Le poster du projet (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse et rédaction · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous devez présenter un poster (format A0) sur votre projet de stage lors d'une journée régionale de diététiciens. Votre camarade vous montre son premier jet sur un autre projet, mené dans une maison des jeunes.

Document 1 – Description du premier jet de poster

- Titre : « Projet alimentation 2026-2027 ».
- Le texte occupe environ 80 % de la surface, en police de 14 points, en trois longues colonnes ; il reprend mot pour mot l'introduction du dossier.
- Une photo de groupe où l'on reconnaît six jeunes, sans mention d'autorisation.
- Un graphique en camembert en trois dimensions de la satisfaction, sans effectif.
- Aucun résultat sur les objectifs spécifiques ; la méthode d'évaluation n'est pas présentée.
- Les logos des partenaires occupent tout le bas du poster ; aucun contact.

À vous de jouer – Questions

1. Relevez six défauts du premier jet et expliquez chacun. (4,5 pts)
2. Proposez un plan de poster en sept rubriques. (3,5 pts)
3. Proposez un titre accrocheur et précis pour ce projet de maison des jeunes. (1 pt)
4. Indiquez trois règles de mise en forme pour qu'un poster se lise à deux mètres. (1,5 pt)
5. Préparez la phrase de présentation de 30 secondes que vous direz aux visiteurs. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.41 – Restituer aux participants en respectant l'éthique (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service de santé au travail (structure fictive) a mené un projet « Manger en déplacement » avec les 14 techniciens itinérants d'une petite entreprise (12 hommes et 2 femmes). Le chef d'équipe propose de présenter les résultats lors de la réunion mensuelle, en présence de la direction.

Document 1 – Projet de diaporama de restitution préparé par le chef d'équipe

- Diapositive 2 : « Résultats des femmes : 1 sur 2 saute encore le déjeuner. »
- Diapositive 3 : tableau des scores du quiz, technicien par technicien, avec les prénoms.
- Diapositive 4 : « Les techniciens en surpoids ont moins progressé que les autres. »
- Diapositive 5 : photo d'un technicien mangeant un sandwich dans sa camionnette, prise à son insu, avec la légende « À ne plus faire ! ».
- Diapositive 6 : « Merci à tous ! Prochaine étape : la direction décidera. »

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque diapositive 2 à 6, expliquez le problème éthique ou de communication. (5 pts)

2. Proposez une correction pour chacune. (3 pts)

3. Indiquez trois règles générales pour une restitution respectueuse aux participants. (2 pts)

4. Quels résultats faut-il éviter de présenter devant la direction, et pourquoi ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.42 – Le graphique honnête (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de santé pluriprofessionnelle (structure fictive) présente dans son rapport d'activité un graphique sur un projet « Petit-déjeuner des enfants ». Le graphique montre deux barres : « Enfants qui prennent un petit-déjeuner : 62 % en 2026, 68 % en 2027 ». L'axe vertical commence à 60 %. La barre de 2027 paraît quatre fois plus haute que celle de 2026. Aucun effectif n'est indiqué.

Document 1 – Données brutes (données fictives)

- 2026 : 18 enfants sur 29 répondants.
- 2027 : 17 enfants sur 25 répondants.
- Les questionnaires ont été remplis par les parents en salle d'attente ; ce ne sont pas les mêmes enfants les deux années.

À vous de jouer – Questions

1. Vérifiez les deux pourcentages à partir des données brutes. (2 pts)
2. Calculez l'évolution réelle en points et en pourcentage. (2 pts)
3. Calculez l'évolution que suggère la hauteur des barres, puis le « facteur de déformation » (évolution visuelle divisée par évolution réelle). (3 pts)
4. Relevez trois autres défauts de présentation ou d'interprétation de ce graphique. (3 pts)
5. Décrivez le graphique honnête que vous proposez et rédigez sa légende et la phrase de commentaire. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 9.37

1. 1 = **Participants** ; 2 = **Structure et partenaires** ; 3 = **Financeurs** ; 4 = **Professionnels** ; 5 = **Décideurs** ; 6 = **Grand public**.
2. a) Financeurs (CAF, ville). b) Participants (et bénévoles de l'association). c) Professionnels. d) Grand public (habitants). e) Décideurs (élus). f) Structure et partenaires. g) Professionnels (transfert). h) Grand public et participants.
3. Exemples : les **financeurs** attendent la preuve que la subvention a été utilisée comme prévu (réalisations, dépenses justifiées) et que les objectifs ont été atteints ; les **décideurs** attendent quelques chiffres clés, le coût et une proposition claire ; les **participants** attendent de savoir ce que le groupe a obtenu, que leur avis a compté et ce qui va suivre ; les **professionnels** attendent la méthode, les résultats et les conditions de transfert.
4. Parce que ce sont eux qui ont fourni les données et fait l'effort de changer : la restitution est une marque de **respect**, elle renforce leur motivation et leur permet de corriger ou de compléter l'interprétation. C'est aussi une exigence éthique (droit de savoir ce que l'on a fait de leurs réponses).

Corrigé – Exercice 9.38

1. Écarts (réalisé − prévu) :

Poste	Écart (€)	Écart (%)
Denrées	− 250	− 10,4 %
Petit matériel	+ 180	+ 13,8 %
Intervenants	− 900	− 25,0 %
Communication	− 180	− 25,7 %
Déplacements	− 90	− 22,5 %
Frais de structure	− 160	− 20,0 %
Total	− 1 400	− 15,2 %

Taux de réalisation du budget : 7 800 / 9 200 × 100 = **84,8 %**.

2. Postes à expliquer (écart de plus de 15 %) : **intervenants** (deux ateliers annulés à cause de la grève, donc moins d'heures d'intervention) ; **communication** (moins d'affiches, impression faite en interne) ; **déplacements** (deux déplacements en moins, covoiturage) ; **frais de structure** (calculés en proportion des dépenses directes, ils baissent avec elles). Le petit matériel (+ 13,8 %) et les denrées (− 10,4 %) restent sous le seuil, mais on peut expliquer la hausse du matériel (remplacement d'un mixeur, par exemple).
3. Subvention accordée : 50 % × 9 200 = **4 600 €**. Subvention due : 50 % × 7 800 = **3 900 €**. Déjà versé : 70 % × 4 600 = **3 220 €**. Solde à verser : 3 900 − 3 220 = **680 €** (au lieu de 1 380 €).
4. Reversement : 4 600 − 3 900 = **700 €**.
5. La convention oblige en général à **informer** le financeur de toute modification du projet ; prévenir tôt maintient la confiance, permet de proposer un report des ateliers ou une autre utilisation des fonds avec son accord, et évite un reversement ou un refus de financement l'année suivante.

Corrigé – Exercice 9.39

1. Couverture : 96 / 1 450 = **6,6 %**. Présence : 480 / (96 × 6) = 480 / 576 = **83,3 %** (chaque participant pouvait assister aux 6 ateliers de son cycle). Répondants : 80 / 96 = **83,3 %**. Produit laitier à chaque repas : 34 / 80 = **42,5 %** → 55 / 80 = **68,8 %** (+ 26,3 points). Repas du soir seuls : 41 / 80 = **51,3 %** → 30 / 80 = **37,5 %** (−

13,8 points). Coût par participant : 14 400 / 96 = **150 €** ; pour la commune : 7 200 / 96 = **75 €**.

2. Exemples : la **progression** du produit laitier (+ 26,3 points), lien direct avec la prévention de la dénutrition ; la baisse des **repas seuls** (lien social, préoccupation des élus) ; le **coût pour la commune** (75 € par participant), utile pour la décision. On peut citer aussi la présence élevée ou la satisfaction (74 sur 80).

3. Exemple de note :

Objet : renouvellement et extension du programme « Bien vieillir à table » en 2028.

Contexte : la commune compte 1 450 habitants de 70 ans et plus. En 2027, elle a financé la moitié d'un programme de 24 ateliers dans 4 hameaux.

Résultats : 96 habitants ont participé, avec une présence de 83 %. Parmi les 80 participants interrogés avant et après, la part qui consomme un produit laitier à chaque repas est passée de 42,5 % à 68,8 %, et la part qui dîne seule tous les soirs de 51,3 % à 37,5 %. 74 participants sur 80 recommanderaient les ateliers. Le coût pour la commune est de 75 € par participant.

Limites : 6,6 % seulement des habitants concernés ont été touchés ; les résultats sont déclaratifs et mesurés en fin de cycle, sans recul.

Proposition : renouveler le programme en 2028 et l'étendre à deux hameaux supplémentaires, pour un coût supplémentaire de 3 600 € pour la commune, en ajoutant une mesure à six mois.

Décision demandée : approbation par le conseil municipal du renouvellement (7 200 €) et de l'extension (3 600 €), soit 10 800 € au budget 2028.

Corrigé – Exercice 9.40

1. Défauts : **titre** vague, qui ne dit ni le public ni l'action ; **trop de texte** et police trop petite (illisible à distance), texte copié du dossier ; **photo** de mineurs identifiables sans autorisation (droit à l'image, accord des titulaires de l'autorité parentale) ; **camembert en 3D** sans effectif, qui déforme les proportions ; **pas de résultats** sur les objectifs ni de méthode, alors que c'est l'essentiel pour des professionnels ; **logos** trop envahissants et **pas de contact** pour échanger.

2. Plan : titre et auteurs ; contexte et constat de départ (deux ou trois chiffres) ; objectifs ; actions mises en place ; méthode d'évaluation ; résultats (graphiques) ; conclusion, limites et perspectives, avec contact et partenaires en petit.

3. Exemple : « Des jeunes aux fourneaux : un défi petit-déjeuner à la maison des jeunes ».

4. Titre de 80 à 100 points et texte d'au moins 24 points ; moins de 400 mots au total, beaucoup de graphiques et de schémas ; trois ou quatre couleurs au plus, bon contraste, lecture de gauche à droite et de haut en bas.

5. Exemple : « Avec 18 jeunes de la maison des jeunes, nous avons organisé six ateliers petit-déjeuner ; la part qui mange le matin est passée de 8 à 13 jeunes, surtout grâce aux recettes faites en cinq minutes. »

Corrigé – Exercice 9.41

1. et 2. :

Diapositive	Problème	Correction
2	Avec 2 femmes, le résultat **identifie** une personne (petit effectif isolé).	Ne pas présenter de sous-groupe de moins de 5 personnes ; donner le résultat du groupe entier.
3	Résultats **individuels nominatifs** : atteinte à la confidentialité, risque de jugement.	Résultats collectifs uniquement ; chacun peut recevoir son propre score en privé s'il le souhaite.
4	Donnée de **santé** (surpoids) révélée et formulation **stigmatisante**.	Supprimer ; ces données relèvent du secret médical du service de santé au travail.

Diapositive	Problème	Correction
5	Photo **sans consentement** et légende **culpabilisante**.	Supprimer ; utiliser une photo prise avec accord ou une illustration, et parler des solutions (« Trois idées pour un déjeuner en déplacement »).
6	Les participants sont **exclus** de la suite du projet.	Proposer de construire la suite avec eux (« Vos idées pour la suite ») avant la décision de la direction.

3. Résultats **collectifs** et anonymes ; langage **positif**, sans jugement ni culpabilisation ; laisser la parole aux participants pour commenter et compléter les résultats ; respecter le droit à l'image ; présenter aussi ce qui va changer grâce à leur avis.

4. Tout résultat qui pourrait **identifier** une personne ou porter sur sa **santé**, et les résultats individuels : la direction est l'employeur, ces informations pourraient influencer son jugement sur les salariés. Le service de santé au travail est tenu au secret médical et à l'indépendance.

Corrigé – Exercice 9.42

1. 2026 : 18 / 29 = **62,1 %** ; 2027 : 17 / 25 = **68,0 %**. Les pourcentages arrondis sont justes.

2. Évolution réelle : 68 − 62 = **+ 6 points** ; en pourcentage : (68 − 62) / 62 × 100 = **+ 9,7 %**.

3. Avec un axe qui part de 60 %, les barres mesurent 2 et 8 unités : évolution visuelle (8 − 2) / 2 × 100 = **+ 300 %**. Facteur de déformation : 300 / 9,7 = **31** : le graphique exagère l'évolution 31 fois.

4. Exemples : **effectifs** absents (29 et 25 répondants seulement) ; ce ne sont **pas les mêmes enfants** (pas de comparaison appariée) ; réponses des **parents** en salle d'attente (désirabilité sociale, enfants qui consultent, donc non représentatifs) ; pas de **source** ni de date de recueil ; le **nombre** d'enfants qui prennent un petit-déjeuner a même baissé (18 puis 17) : la hausse du pourcentage vient de la baisse du nombre de répondants.

5. Graphique en barres avec un axe de **0 à 100 %**, deux barres de même couleur, l'effectif sous chaque barre (« n = 29 », « n = 25 »), le pourcentage au-dessus. Légende : « Part des enfants qui prennent un petit-déjeuner selon leurs parents, questionnaires remplis en salle d'attente, maison de santé (données fictives), 2026 et 2027. » Commentaire : « La part déclarée est stable, de 62 % (18 enfants sur 29) à 68 % (17 sur 25) ; sur de si petits effectifs, composés d'enfants différents, cette différence ne permet pas de conclure à un effet du projet. »

Partie 8 – Décider, transférer et s'entraîner sur un cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Prendre une décision argumentée à partir d'une évaluation : poursuivre, ajuster, arrêter ou étendre.
- Analyser la transférabilité d'une action avec la grille ASTAIRE.
- Rédiger une fiche de capitalisation.
- Rédiger la partie « évaluation » d'un dossier de projet.
- Préparer la présentation orale de l'évaluation.
- Traiter un cas complet au format de l'épreuve.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- L'évaluation sert à **décider** : poursuivre à l'identique, **ajuster** (modifier ce qui ne marche pas), **arrêter** (action inefficace, trop coûteuse ou aux effets indésirables), **étendre** (à d'autres publics ou d'autres lieux).
- Une décision s'appuie sur des **critères** (efficacité, efficience, équité, pertinence, viabilité) et sur les **moyens** disponibles.
- Transférabilité : distinguer les **fonctions clés** (ce qui produit l'effet, à conserver) et les **éléments adaptables** (forme, horaires, recettes). La grille ASTAIRE (Cambon et coll., 2013) analyse quatre dimensions : population, environnement, mise en œuvre, accompagnement du transfert.
- Une fiche de capitalisation raconte l'expérience pour qu'un autre professionnel puisse s'en inspirer : contexte, actions, résultats, facteurs de réussite, difficultés, conseils.
- Partie « évaluation » d'un dossier : rappel des objectifs et indicateurs, méthode et outils, résultats chiffrés avec effectifs, interprétation, limites, propositions.

Exercice 9.43 – Décider après l'évaluation (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – analyse guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le comité de pilotage d'un contrat local de santé (territoire fictif) examine les bilans de quatre actions financées l'an dernier. Vous préparez une proposition de décision pour chacune.

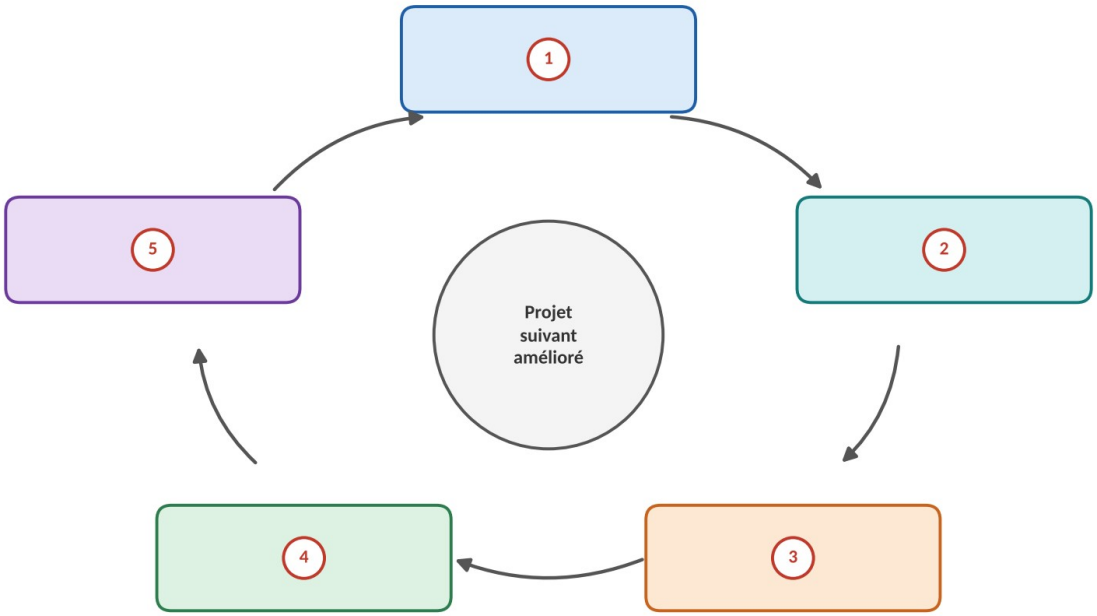


Figure 9.11 – Document 1 – La boucle de l'évaluation à la décision (schéma à légender)

Document 2 – Résumé des quatre bilans (données fictives)

- **Action 1 – Petit-déjeuner à l'école** (2 écoles) : objectifs spécifiques atteints dans les deux écoles ; coût de 18 € par élève ; les enseignants veulent continuer ; quatre autres écoles du territoire demandent l'action.
- **Action 2 – Ateliers cuisine pour seniors** : objectif atteint chez les participants réguliers ; 14 participants sur 350 seniors visés ; taux de présence de 52 % ; les participants trouvent l'horaire (9 h) trop matinal et le lieu difficile d'accès.
- **Action 3 – Distribution de 6 000 dépliants sur le sucre en gare** : coût de 3 200 € ; aucune évolution des connaissances lors d'un sondage avant / après ; beaucoup de dépliants retrouvés dans les poubelles de la gare.
- **Action 4 – Jardin thérapeutique en EHPAD** : objectifs atteints, maintien constaté à six mois, personnel formé et motivé, financement assuré par l'EHPAD pour trois ans.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Pour chaque action, proposez une décision (poursuivre, ajuster, arrêter, étendre) et justifiez-la avec au moins un critère d'évaluation. (6 pts)
3. Pour l'action 2, calculez le taux de couverture et proposez deux ajustements. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.44 – Analyser la transférabilité avec ASTAIRE (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans la ville A (ville fictive), un projet « Cuisine à petit prix » donne de bons résultats depuis trois ans auprès de familles monoparentales. La ville B, voisine, veut le reprendre pour ses retraités à faibles revenus. Le CCAS de la ville B vous demande d'analyser les conditions du transfert.

Document 1 – Dix éléments du projet de la ville A

a) Les bénéficiaires choisissent eux-mêmes les recettes du cycle suivant.

b) Les ateliers ont lieu le mardi à 14 h, pendant que les enfants sont à l'école.

c) Toutes les recettes coûtent moins de 1,50 € par portion.

d) Les ateliers sont animés par une conseillère en économie sociale et familiale formée à l'animation.

e) L'épicerie sociale fournit les produits et oriente les familles vers les ateliers.

f) Les recettes du livret sont surtout des plats familiaux pour enfants.

g) Le public est composé de familles monoparentales de 25 à 45 ans.

h) La salle dispose d'une cuisine équipée de six postes.

i) Un comité de pilotage réunit le CCAS et l'épicerie chaque trimestre.

j) L'équipe de la ville A propose d'accompagner la ville B pendant six mois.

À vous de jouer – Questions

1. Classez les dix éléments dans les quatre dimensions de la grille ASTAIRE. (4 pts)
2. Indiquez quatre fonctions clés à conserver et quatre éléments à adapter. (4 pts)
3. Proposez une adaptation concrète pour trois éléments à adapter. (3 pts)
4. Pourquoi le succès dans la ville A ne garantit-il pas le succès dans la ville B ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.45 – La fiche de capitalisation (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – rédaction · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service de santé universitaire (structure fictive) veut partager son expérience sur une base de capitalisation des actions de promotion de la santé. Le responsable vous remet le récit ci-dessous et vous demande de le transformer en fiche.

Document 1 – Le récit du responsable

« Tout est parti d'une enquête de 2025 : un étudiant sur trois disait sauter le déjeuner au moins deux fois par semaine, souvent par manque d'argent. Avec le restaurant universitaire et deux associations étudiantes, nous avons lancé en 2026 des "midis à 1 €" un jeudi sur deux, avec un atelier de dix minutes animé par une diététicienne et des étudiants relais formés. Le budget de 6 800 € a été financé par l'agence régionale de santé et l'université. Au début, peu d'étudiants venaient : l'information passait par courriel et personne ne les lisait. Quand les étudiants relais ont fait des vidéos courtes sur les réseaux sociaux, la fréquentation a triplé. Nous avons touché 620 étudiants différents en un an. Parmi les 210 qui ont répondu au questionnaire avant et après, la part de ceux qui sautent le déjeuner au moins deux fois par semaine est passée de 34 % à 22 %. Le plus difficile a été de trouver des créneaux compatibles avec tous les emplois du temps. Si c'était à refaire, nous impliquerions les étudiants relais dès la conception. »

À vous de jouer – Questions

1. Construisez la fiche de capitalisation en dix rubriques, remplies à partir du récit. (7 pts)
2. Repérez deux facteurs de réussite et deux difficultés, et formulez deux conseils pour un autre service. (3 pts)
3. Indiquez une information importante qui manque au récit pour qu'un autre professionnel puisse juger les résultats. (1 pt)
4. Quelle est la différence entre une fiche de capitalisation et un bilan destiné au financeur ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.46 – Rédiger la partie « évaluation » du dossier (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – calcul et rédaction · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un camarade a mené son projet de stage dans un club de football amateur (club fictif) : six séances « Bien récupérer » pour 18 joueurs de 15 à 17 ans, avec une collation préparée par les joueurs après l'entraînement. Son objectif spécifique était : « À la fin du projet, au moins 60 % des joueurs prennent une collation adaptée dans l'heure qui suit l'entraînement. » Il vous montre son premier jet de la partie « évaluation ».

Document 1 – Le premier jet

« L'évaluation a été très positive, les jeunes ont adoré. J'ai fait un questionnaire au début et à la fin. La plupart des joueurs prennent maintenant une collation. Le budget a été respecté. Je pense que le projet a vraiment changé les habitudes des joueurs et qu'il devrait être proposé à tous les clubs du département. »

Document 2 – Les données recueillies (données fictives)

- Présences aux 6 séances : 17, 16, 15, 16, 14, 15.
- 16 joueurs ont répondu au questionnaire au début et à la fin : 3 prenaient une collation adaptée aux deux temps ; 1 au début seulement ; 8 à la fin seulement ; 4 à aucun des deux temps.
- Budget prévu : 1 850 € ; budget réalisé : 1 720 €.
- Remarque de l'entraîneur : « Les joueurs les plus jeunes oublient souvent leur collation quand l'entraînement finit tard. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez quatre défauts du premier jet. (2 pts)
2. Calculez le taux de présence, le taux de répondants, les pourcentages avant et après, le taux d'atteinte de l'objectif et le test de McNemar. (5 pts)
3. Calculez le taux de réalisation du budget. (1 pt)
4. Rédigez la partie « évaluation » en cinq paragraphes : méthode, résultats, interprétation, limites, propositions. (6 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.47 – Présenter l'évaluation à l'oral (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – préparation de l'oral · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous présentez votre projet de stage devant un jury : 10 minutes de présentation, puis 10 minutes d'échange. Votre projet portait sur des ateliers « Goûter maison » dans un accueil périscolaire (structure fictive) ; l'objectif spécifique est atteint (64 % des enfants apportent un goûter sans produit sucré industriel, pour une cible de 60 %), mais seuls 22 parents sur 40 ont répondu au questionnaire final.

Document 1 – Le plan de votre diaporama et le temps prévu

Diapositive	Contenu	Temps prévu
1	Titre et présentation de la structure	1 min
2	Diagnostic et problème retenu	1 min 30
3	Objectifs	1 min 30
4	Actions réalisées	2 min
5	Évaluation : méthode et résultats	2 min 30
6	Limites, décisions et perspectives	1 min 30

À vous de jouer – Questions

1. Vérifiez que le minutage respecte les 10 minutes. Que conseillez-vous si vous dépassez le temps lors de la répétition ? (2 pts)
2. Indiquez ce que doit montrer la diapositive 5 (quatre éléments) et comment présenter les résultats pour qu'ils soient lisibles. (3 pts)
3. Préparez une réponse de trois ou quatre phrases à la question du jury : « Avec 22 répondants sur 40, pouvez-vous vraiment dire que votre objectif est atteint ? » (3 pts)
4. Préparez une réponse à la question : « Si c'était à refaire, que changeriez-vous dans votre évaluation ? » (2 pts)
5. Donnez quatre conseils de posture et de communication pour l'oral. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9.48 – Cas complet : la « pause qui compte » d'une plateforme téléphonique (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 h*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage dans le service de santé au travail qui suit la plateforme téléphonique « Allô Services » (entreprise fictive). La plateforme emploie 180 téléconseillers répartis en trois équipes : matin (6 h – 14 h, 60 agents), journée (9 h – 17 h, 70 agents) et soir (14 h – 22 h, 50 agents). Les pauses durent 20 minutes ; la cafétéria est ouverte de 11 h 30 à 14 h. En 2026, beaucoup d'agents déjeunaient devant leur écran ou grignotaient au distributeur. De janvier à juin 2027, le projet « La pause qui compte » a mis en place un salad-bar à la cafétéria, un distributeur réaménagé (fruits, produits laitiers, eau) et quatre ateliers de 45 minutes animés par une diététicienne. Le comité social et économique (CSE) attend un bilan à six mois. La mutuelle de l'entreprise a financé une partie du projet.

Document 1 – Extrait du plan d'évaluation prévu (à compléter)

Objectif	Indicateur	Valeur initiale	Valeur cible	Source
OS1 : à compléter	Part des agents qui déjeunent assis, hors poste de travail, au moins 4 jours sur 5	45 %	60 %	Questionnaire apparié
OS2 : à compléter	Part des produits « favorables » (fruits, produits laitiers, eau) dans les ventes du distributeur	à calculer	40 %	Relevés du prestataire
Réalisation	Taux de participation aux ateliers	–	50 %	Feuilles de présence
Équité	à compléter	–	–	–

Document 2 – Réponses appariées des 120 agents qui ont répondu en décembre 2026 et en juin 2027 (données fictives) : « Déjeunez-vous assis, hors de votre poste, au moins 4 jours sur 5 ? »

	« Oui » en juin	« Non » en juin
« Oui » en décembre	48	6
« Non » en décembre	30	36

Document 3 – Résultats par équipe (données fictives)

Équipe	Agents	Agents ayant suivi au moins un atelier	Répondants	« Oui » en décembre	« Oui » en juin
Matin	60	18	40	18	24
Journée	70	38	50	26	39
Soir	50	6	30	10	15
Total	180	62	120	54	78

Document 4 – Ventes mensuelles du distributeur (données fictives)

Produit	Novembre 2026	Mai 2027
Barres chocolatées et biscuits	1 240	860
Sodas	980	720
Fruits frais	0	410

Produit	Novembre 2026	Mai 2027
Produits laitiers	0	260
Eau	520	690

Document 5 – Coûts du projet sur six mois (données fictives)

- Diététicienne : 32 heures à 55 € de l'heure.
- Location du salad-bar : 180 € par mois.
- Affiches et livret : 240 €.
- Temps de l'infirmière pour le questionnaire et son analyse : 24 heures à 28 € de l'heure.
- Participation de la mutuelle : 2 000 €.

Document 6 – Le « bol du salad-bar » : grammages nets par portion, pertes et prix (fictifs) et extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Net par portion	Perte	Prix	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Lentille verte, bouillie/cuite à l'eau (20587)	120 g	–	3,20 € le kg	125	10,1	16,2	0,58	8,45	0,015
Boulgour de blé, cuit, sans sel ajouté (9691)	100 g	–	2,40 € le kg	131	4,31	24,1	1	3,7	0,033
Carotte, crue (20009)	60 g	10 %	1,60 € le kg	30,2	0,78	5,16	< 0,5	2,9	0,12
Tomate sans précision, crue (20385)	60 g	5 %	2,90 € le kg	19,2	0,6	3,69	< 0,5	1,02	< 0,013
Oeuf dur (22010)	50 g (1 œuf)	–	0,28 € l'œuf	134	13,5	0,52	8,62	0	0,31
Huile de colza (17130)	10 g	–	3,20 € le kg	900	0	0	100	0	< 0,0028
Pain complet ou intégral, farine T150 (7110)	40 g	–	4,50 € le kg	234	8,66	41,2	1,7	7,3	1,17
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	125 g (1 pot)	–	0,25 € le pot	50,1	3,83	4,26	1,68	traces	0,1

Les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0. Forfait condiments et vinaigre : 3,00 € pour 60 portions.

Document 7 – Extraits de l'entretien collectif avec 8 agents (2 par équipe, plus 2 représentants du CSE)

- « Le salad-bar, c'est génial, je ne mange plus devant mon écran. » (équipe journée)
- « Ma pause repas est à 18 h : la cafétéria est fermée, il ne reste que le distributeur, et le soir il n'y a plus de fruits. » (équipe soir)
- « En 20 minutes, entre la queue et le retour au poste, je n'ai pas le temps de m'asseoir. » (équipe matin)
- « Les ateliers étaient à 10 h : pour nous, l'équipe du soir, il fallait revenir exprès. » (équipe soir)
- « On mange ensemble maintenant, l'ambiance de l'équipe a changé. » (équipe journée)

- « Le classement des équipes affiché à la cafétéria, ça met la pression. » (représentant du CSE)

À vous de jouer – Questions

Partie A – Le plan d'évaluation (8 points)

1. Rédigez l'objectif spécifique OS1 et l'objectif spécifique OS2 avec leurs critères, puis proposez un indicateur d'équité avec sa valeur cible. (5 pts)

2. Indiquez le type de plan d'évaluation utilisé et deux de ses limites. (3 pts)

Partie B – Les résultats quantitatifs (12 points)

3. À partir du document 2, calculez le taux de répondants, les pourcentages en décembre et en juin, l'évolution en points, et la part des agents qui ont progressé parmi ceux qui pouvaient progresser. (3 pts)

4. Appliquez le test de McNemar et concluez. (2 pts)

5. À partir du document 4, calculez la part des produits favorables avant et après, et l'évolution des ventes de barres chocolatées et de sodas. Concluez sur OS2. (3 pts)

6. À partir du document 3, calculez le taux de participation aux ateliers (global et par équipe) et l'évolution par équipe. Concluez sur l'équité. (4 pts)

Partie C – Coût et qualité nutritionnelle (8 points)

7. Calculez le coût total du projet, le coût par agent, le coût par agent ayant progressé, et le coût restant pour l'entreprise. (3 pts)

8. Calculez le coût d'une portion du bol pour 60 portions, puis ses apports en énergie, protéines, glucides, lipides, fibres et sel, la part de l'énergie apportée par chaque macronutriment et la part de la référence de 30 g de fibres par jour. Commentez. (5 pts)

Partie D – Analyse qualitative et interprétation (7 points)

9. Codez les verbatims du document 7 en thèmes, en distinguant leviers, freins et effets inattendus. (3 pts)

10. Interprétez en quatre temps les résultats de l'équipe du soir. (4 pts)

Partie E – Décision et valorisation (5 points)

11. Proposez une décision argumentée sur la suite du projet, avec trois ajustements. (3 pts)

12. Rédigez le plan de la note de bilan destinée au CSE (six rubriques) et la phrase de conclusion. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 9.43

1. 1 = **Évaluer** ; 2 = **Juger avec des critères** ; 3 = **Décider : poursuivre, ajuster, arrêter, étendre** ; 4 = **Restituer et valoriser** ; 5 = **Capitaliser et transférer**.
2. Action 1 : **étendre** aux quatre écoles demandeuses (efficacité démontrée, coût raisonnable, adhésion des acteurs, demande du terrain), en gardant l'évaluation. Action 2 : **ajuster** (efficace chez les présents, mais portée et présence très faibles : problème de mise en œuvre, horaire et lieu) ; Action 3 : **arrêter** (inefficace et peu efficiente, gaspillage de papier ; réorienter le budget vers une action de proximité). Action 4 : **poursuivre** (efficacité, maintien et viabilité assurés), et capitaliser l'expérience pour d'autres EHPAD.
3. Couverture : 14 / 350 = **4,0 %**. Ajustements : déplacer l'atelier en fin de matinée ou en début d'après-midi ; l'organiser dans un lieu proche (salle de quartier, résidence autonomie) ou proposer un transport ; mobiliser les relais (aides à domicile, clubs de retraités) pour l'information.

Corrigé – Exercice 9.44

1. **Population** : a) participation au choix des recettes, f) recettes pour enfants, g) public de familles monoparentales. **Environnement** : b) horaire du mardi à 14 h, e) partenariat avec l'épicerie sociale, h) cuisine équipée. **Mise en œuvre** (porteurs et intervenants) : c) recettes à moins de 1,50 €, d) animatrice formée, i) comité de pilotage. **Accompagnement du transfert** : j) accompagnement par l'équipe de la ville A. (D'autres classements sont acceptés s'ils sont justifiés, par exemple c) dans la population, car il répond à son budget.)
2. Fonctions clés (ce qui produit l'effet) : la **participation** des bénéficiaires aux choix (a) ; des recettes à **petit prix** (c) ; une **animation par un professionnel formé** (d) ; un **partenariat** qui fournit les produits et oriente le public (e) ; on peut ajouter le pilotage partagé (i). Éléments adaptables : l'**horaire** (b), les **recettes** du livret (f), le **public** (g), la **salle** (h), dans la limite où elle permet de cuisiner.
3. Exemples : b) choisir un horaire adapté aux retraités (fin de matinée, suivi d'un repas pris ensemble, ce qui lutte contre l'isolement) ; f) refaire le livret avec des recettes pour une ou deux personnes, des textures faciles et des produits laitiers, et le construire avec les retraités ; g) adapter la communication (clubs, aides à domicile, CCAS) et les supports (gros caractères) ; h) vérifier l'accessibilité de la salle (ascenseur, chaises, plans de travail à bonne hauteur).
4. Les résultats dépendent du **contexte** : le public, ses besoins et ses habitudes, les partenaires et les ressources de la ville B sont différents. Il faut garder les fonctions clés, adapter le reste et **évaluer à nouveau** dans la ville B.

Corrigé – Exercice 9.45

1. Exemple de fiche :

Rubrique	Contenu
Titre	« Midis à 1 € » : lutter contre le déjeuner sauté chez les étudiants
Porteur et partenaires	Service de santé universitaire ; restaurant universitaire ; deux associations étudiantes
Contexte et constat	Enquête de 2025 : un étudiant sur trois saute le déjeuner au moins deux fois par semaine, souvent par manque d'argent
Public	Étudiants de l'université
Objectifs	Réduire la part des étudiants qui sautent le déjeuner ; faciliter l'accès à un repas équilibré
Actions	Repas à 1 € un jeudi sur deux, atelier de 10 minutes animé par une diététicienne et des étudiants relais formés

Rubrique	Contenu
Moyens et financement	6 800 € (agence régionale de santé, université) ; diététicienne ; étudiants relais
Évaluation et résultats	620 étudiants différents touchés en un an ; parmi 210 répondants avant et après, déjeuner sauté au moins deux fois par semaine : 34 % → 22 %
Facteurs de réussite et difficultés	Vidéos courtes des étudiants relais (fréquentation triplée) ; difficultés : information par courriel peu lue, créneaux compatibles avec les emplois du temps
Enseignements et contact	Impliquer les étudiants relais dès la conception ; coordonnées du service

2. Facteurs de réussite : le **prix** très bas, qui répond à la cause principale ; les **pairs** (étudiants relais) et des **canaux adaptés** (vidéos courtes). Difficultés : le **canal** d'information initial inadapté ; les **créneaux**. Conseils : associer le public dès la conception ; tester les canaux de communication avec quelques étudiants avant le lancement.
3. Exemples : le **nombre d'étudiants** ciblés (pour calculer la couverture) ; la méthode d'évaluation précise (questionnaire apparié ? même question ?) ; le maintien après l'arrêt de l'action ; le coût par étudiant (6 800 / 620 = 11,0 €, calculable mais à indiquer).
4. Le bilan au financeur **rend compte** de l'utilisation de la subvention et de l'atteinte des objectifs ; la fiche de capitalisation **partage** l'expérience (ce qui a marché, ce qui a été difficile, les conseils) pour que d'autres professionnels puissent s'en inspirer.

Corrigé – Exercice 9.46

1. Défauts : jugement **subjectif** sans chiffre (« très positive », « ont adoré ») ; « la plupart » sans **effectif** ni pourcentage ; pas de **comparaison à la cible** ; conclusion **abusive** (« a vraiment changé les habitudes ») et **généralisation** à tous les clubs ; aucune **limite** ; budget « respecté » sans chiffres.
2. Présence : (17 + 16 + 15 + 16 + 14 + 15) / (6 × 18) = 93 / 108 = **86,1 %**. Répondants : 16 / 18 = **88,9 %**. Avant : (3 + 1) / 16 = **25,0 %** ; après : (3 + 8) / 16 = **68,8 %** (+ 43,8 points). Taux d'atteinte : 68,8 / 60 × 100 = **114,6 %**. McNemar : $\chi^2 = (|1 - 8| - 1)^2 / (1 + 8) = 36 / 9 =$ **4,00**, supérieur à 3,84, mais b + c = 9 est inférieur à 10 : le résultat est à interpréter avec prudence.
3. Budget : 1 720 / 1 850 × 100 = **93,0 %** (130 € de moins que prévu).
4. Exemple : « **Méthode** : nous avons suivi la présence aux six séances et fait remplir le même questionnaire au début et à la fin du projet ; 16 joueurs sur 18 ont répondu aux deux temps. **Résultats** : la présence moyenne est de 86,1 %. La part des joueurs qui prennent une collation adaptée dans l'heure qui suit l'entraînement est passée de 4 sur 16 (25,0 %) à 11 sur 16 (68,8 %), pour une cible de 60 % : l'objectif est atteint (114,6 %). Le budget a été réalisé à 93,0 %. **Interprétation** : 8 joueurs ont adopté la collation et un seul l'a abandonnée ; le test de McNemar (4,00) indique une évolution probablement réelle, mais l'effectif de changements est faible. La préparation de la collation par les joueurs eux-mêmes semble avoir favorisé l'appropriation. **Limites** : les réponses sont déclaratives, mesurées juste après le projet, sur un petit groupe et sans groupe de comparaison ; les jeunes les plus jeunes oublient leur collation après les entraînements tardifs. **Propositions** : mesurer le maintien dans trois mois, prévoir une collation de secours au club pour les entraînements tardifs, associer les parents, et proposer le projet à d'autres équipes du club avant d'envisager d'autres clubs. »

Corrigé – Exercice 9.47

1. 1 + 1,5 + 1,5 + 2 + 2,5 + 1,5 = **10 minutes** : le minutage est juste, sans marge. Si vous dépassez, raccourcissez la présentation de la structure et du diagnostic (diapositives 1 et 2), jamais l'évaluation ;

répétez avec un chronomètre et gardez une diapositive « de secours » que l'on peut sauter.

2. Diapositive 5 : les **outils** utilisés (questionnaire, observation), les **effectifs** (22 répondants sur 40), le **résultat** comparé à la cible (64 % pour 60 %) et un **graphique** simple ; une seule idée par diapositive, des chiffres arrondis, un graphique en barres avec axe à zéro et effectifs, une phrase de conclusion en bas.

3. Exemple : « Vous avez raison, 22 répondants sur 40, c'est 55 % des parents : le résultat ne porte que sur eux. Les parents qui n'ont pas répondu sont peut-être ceux qui ont le moins changé, donc le résultat réel pourrait être plus faible. Je peux dire que l'objectif est atteint chez les répondants ; pour tous les enfants, l'observation des goûters apportés aurait été une mesure plus complète. C'est une limite que j'ai indiquée dans mon dossier. »

4. Exemple : « J'aurais complété le questionnaire par une **observation** des goûters apportés pendant une semaine, avant et après, pour avoir une mesure qui ne dépend pas des réponses des parents ; j'aurais aussi relancé les parents à la sortie de l'accueil pour augmenter le taux de réponse. »

5. Regarder tous les membres du jury ; parler lentement et sans lire ; utiliser le vocabulaire professionnel (indicateur, taux d'atteinte, limites) ; reconnaître une limite sans se justifier longuement ; écouter la question jusqu'au bout et prendre quelques secondes avant de répondre ; tenue adaptée.

Corrigé – Exercice 9.48

Partie A

1. OS1 : « En juin 2027, au moins 60 % des agents déjeunent assis, hors de leur poste de travail, au moins 4 jours sur 5 (45 % en décembre 2026). » OS2 : « En mai 2027, les fruits, produits laitiers et eau représentent au moins 40 % des ventes mensuelles du distributeur. » Indicateur d'équité : « Écart de progression de l'OS1 entre l'équipe du soir et l'ensemble des agents », valeur cible : progression de l'équipe du soir au moins égale à celle de l'ensemble ; ou « taux de participation aux ateliers de chaque équipe au moins égal à 40 % ».

2. Plan **avant / après sans groupe de comparaison**, avec réponses **appariées**. Limites : on ne peut pas attribuer avec certitude l'évolution au projet (saison, autres facteurs) ; seuls 120 agents sur 180 ont répondu aux deux temps (biais possible : les plus intéressés répondent) ; réponses déclaratives (désirabilité sociale, d'autant plus que le questionnaire vient du service de santé au travail).

Partie B

3. Répondants : 120 / 180 = **66,7 %**. Décembre : (48 + 6) / 120 = 54 / 120 = **45,0 %** ; juin : (48 + 30) / 120 = 78 / 120 = **65,0 %** ; évolution : **+ 20,0 points**. Progression parmi ceux qui pouvaient progresser : 30 / (30 + 36) = 30 / 66 = **45,5 %**. (Régression : 6 / 54 = 11,1 %.)

4. $\chi^2 = (|6 - 30| - 1)^2 / (6 + 30) = 23^2 / 36 = 529 / 36 =$ **14,69**, supérieur à 3,84 (et b + c = 36, supérieur à 10) : l'évolution est **significative** au risque de 5 %. OS1 est atteint (65,0 % pour une cible de 60 %, taux d'atteinte 108,3 %).

5. Novembre : 520 / 2 740 = **19,0 %** de produits favorables ; mai : (410 + 260 + 690) / 2 940 = 1 360 / 2 940 = **46,3 %**. Barres chocolatées : (860 − 1 240) / 1 240 = **− 30,6 %** ; sodas : (720 − 980) / 980 = **− 26,5 %**. OS2 est **atteint** (46,3 % pour une cible de 40 %), même si les ventes totales ont un peu augmenté (2 740 → 2 940).

6. Participation aux ateliers : global 62 / 180 = **34,4 %** (cible de 50 % non atteinte) ; matin 18 / 60 = **30,0 %** ; journée 38 / 70 = **54,3 %** ; soir 6 / 50 = **12,0 %**. Évolution de l'OS1 : matin 18 / 40 = 45,0 % → 24 / 40 = 60,0 % (**+ 15,0 points**) ; journée 26 / 50 = 52,0 % → 39 / 50 = 78,0 % (**+ 26,0 points**) ; soir 10 / 30 = 33,3 % → 15 / 30 = 50,0 % (**+ 16,7 points**). Le projet n'est **pas équitable** : l'équipe du soir, qui partait de plus bas, a très peu participé aux ateliers et reste loin derrière ; l'équipe de journée, la plus favorisée par les horaires, a le plus progressé. Les écarts entre équipes se sont creusés.

Partie C

7. Coût total : 32 × 55 + 6 × 180 + 240 + 24 × 28 = 1 760 + 1 080 + 240 + 672 = **3 752 €**. Par agent : 3 752 / 180 = **20,84 €**. Par agent ayant progressé : 3 752 / 30 = **125,07 €** (sur les répondants seulement). Coût restant pour l'entreprise : 3 752 − 2 000 = **1 752 €**, soit 9,73 € par agent.

8. Coût pour 60 portions : lentilles 7,2 kg × 3,20 = **23,04 €** ; boulgour 6,0 kg × 2,40 = **14,40 €** ; carottes 3,6 / 0,90 = 4,0 kg brut × 1,60 = **6,40 €** ; tomates 3,6 / 0,95 = 3,79 kg brut × 2,90 = **10,99 €** ; œufs 60 × 0,28 = **16,80 €** ; huile 0,6 kg × 3,20 = **1,92 €** ; pain 2,4 kg × 4,50 = **10,80 €** ; yaourts 60 × 0,25 = **15,00 €** ; forfait **3,00 €**. Total **102,35 €**, soit **1,71 €** par portion.

Apports pour une portion : énergie 150,0 + 131,0 + 18,1 + 11,5 + 67,0 + 90,0 + 93,6 + 62,6 = **623,9 kcal** ; protéines **32,3 g** ; glucides **70,9 g** ; lipides **18,8 g** ; fibres **19,1 g** ; sel **0,87 g**. Part de l'énergie : protéines 32,3 × 4 / 623,9 = **20,7 %** ; lipides 18,8 × 9 / 623,9 = **27,1 %** ; glucides 70,9 × 4 / 623,9 = **45,5 %**. Fibres : 19,1 / 30 = **63,7 %** de la référence journalière en un seul repas.

Commentaire : un repas complet (légumineuses, céréale, crudités, œuf, produit laitier, huile de colza riche en oméga 3), bien pourvu en protéines et très riche en fibres, pauvre en sel (hors sel ajouté à table) ; la part des lipides est un peu basse (repère de 35 à 40 % de l'énergie, ANSES, 2016) et celle des glucides se situe dans la fourchette de 40 à 55 % ; l'énergie convient à un déjeuner d'agent sédentaire. Le coût de 1,71 € est compatible avec une cafétéria d'entreprise. On peut ajouter un fruit.

Partie D

9. **Leviers** : le salad-bar apprécié et le repas hors écran ; la **convivialité** (repas pris ensemble). **Freins** : **horaires** de la cafétéria et des ateliers inadaptés à l'équipe du soir ; **durée** de la pause (20 minutes, file d'attente) ; **réapprovisionnement** du distributeur le soir. **Effets inattendus** : positif, l'amélioration de l'ambiance d'équipe ; négatif, la **pression** liée au classement des équipes.

10. **Constater** : dans l'équipe du soir, 15 répondants sur 30 (50,0 %) déjeunent assis en juin, contre 10 sur 30 (33,3 %) en décembre (+ 16,7 points) ; 6 agents sur 50 (12,0 %) ont suivi un atelier. **Comparer** : l'équipe reste sous la cible de 60 % et sous l'ensemble des agents (65,0 %) ; elle a moins progressé que l'équipe de journée (+ 26,0 points). **Expliquer** : la cafétéria est fermée pendant sa pause repas, le distributeur est vide le soir et les ateliers étaient organisés à 10 h ; les agents du soir ont surtout bénéficié des produits du distributeur quand ils étaient disponibles. **Nuancer** : seuls 30 agents sur 50 ont répondu ; les effectifs sont petits ; les réponses sont déclaratives ; les verbatims ne viennent que de deux agents de cette équipe.

Partie E

11. Décision : **poursuivre et ajuster** le projet, qui a atteint OS1 et OS2 pour un coût modéré, en corrigeant son manque d'équité. Ajustements : ouvrir le salad-bar ou proposer des bols préparés en vitrine réfrigérée jusqu'à 20 h pour l'équipe du soir ; réapprovisionner le distributeur en fin d'après-midi ; organiser des ateliers sur chaque créneau d'équipe (dont 16 h – 17 h pour le soir) ; négocier avec la direction et le CSE l'allongement de la pause repas à 30 minutes ; supprimer le classement des équipes. Prévoir une mesure de maintien en décembre 2027.

12. Plan : 1. Rappel du contexte et des objectifs ; 2. Actions réalisées et participation ; 3. Résultats (OS1, OS2, coût) ; 4. Résultats par équipe et équité ; 5. Avis des agents ; 6. Propositions et décisions à prendre par le CSE. Conclusion : « En six mois, la part des agents qui déjeunent assis est passée de 45 % à 65 % et les produits favorables représentent 46 % des ventes du distributeur, pour un coût de 9,73 € par agent pour l'entreprise ; pour que l'équipe du soir en profite autant que les autres, nous proposons d'adapter les horaires de la cafétéria, des ateliers et du réapprovisionnement. »

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Situer les niveaux d'évaluation dans la chaîne des effets ; choisir le moment de l'évaluation ; utiliser les six critères ; distinguer évaluation, suivi et contrôle ; choisir qui évalue ; rédiger des questions évaluatives	9.1 à 9.6			
2	Construire une fiche indicateur ; classer et corriger des indicateurs ; fixer des valeurs cibles ; bâtir un plan d'évaluation ; estimer son temps et son coût	9.7 à 9.12			
3	Choisir un plan d'évaluation ; concevoir un questionnaire avant-après ; adapter les outils au public ; exploiter une grille d'observation et des indicateurs indirects ; gérer les perdus de vue	9.13 à 9.18			
4	Calculer les taux du bilan, une progression et un gain normalisé ; lire un tableau de transition ; appliquer McNemar ; calculer un coût par résultat ; exploiter un groupe de comparaison	9.19 à 9.24			
5	Interpréter en quatre temps ; repérer biais et conclusions abusives ; juger avec RE-AIM ; évaluer l'équité ; repérer les effets indésirables	9.25 à 9.30			
6	Choisir une méthode qualitative ; rédiger un guide d'entretien ; coder des verbatims ; trianguler ; évaluer mon animation ; interpréter une mesure à distance	9.31 à 9.36			
7	Adapter la valorisation ; remplir un compte rendu financier ; rédiger une note aux élus ; construire un poster ; restituer avec éthique ; construire un graphique honnête	9.37 à 9.42			
8	Décider après l'évaluation ; analyser la transférabilité ; rédiger une fiche de capitalisation et la partie évaluation d'un dossier ; préparer l'oral ; traiter un cas complet	9.43 à 9.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

CHAPITRE

09

Démarche de projet (3) : évaluation et valorisation

Démarche de projet (3) | Évaluer | Interpréter | Valoriser | Pérenniser

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 9 232
Mode d'emploi du cahier d'annales 232
Ce que le jury attend sur ce chapitre 232
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 234
S1 – « Avant, je cuisinais pour toute la famille ; ici, je mange du pain et du fromage » : évaluer et valoriser un projet dans une résidence sociale pour travailleurs migrants âgés 234
S2 – « Ma gamelle, c'est moi qui la fais » : un atelier culinaire pour des travailleurs d'un ESAT, et son évaluation 238
S3 – « Le bip sonne toujours quand on passe à table » : évaluer un projet dans un centre de secours, le faire adopter, et animer un atelier « repas de garde » 243
Partie II – Les corrigés détaillés 249
Corrigé S1 – « Avant, je cuisinais pour toute la famille ; ici, je mange du pain et du fromage » : évaluer et valoriser un projet dans une résidence sociale pour travailleurs migrants âgés 249
Corrigé S2 – « Ma gamelle, c'est moi qui la fais » : un atelier culinaire pour des travailleurs d'un ESAT, et son évaluation 255
Corrigé S3 – « Le bip sonne toujours quand on passe à table » : évaluer un projet dans un centre de secours, le faire adopter, et animer un atelier « repas de garde » 261
Grille d'auto-évaluation 268

Cahier d'annales E5 – chapitre 9

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets et les données des enquêtes sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Avant, je cuisinais pour toute la famille ; ici, je mange du pain et du fromage » : évaluer et valoriser un projet dans une résidence sociale pour travailleurs migrants âgés	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Ma gamelle, c'est moi qui la fais » : un atelier culinaire pour des travailleurs d'un ESAT, et son évaluation	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Le bip sonne toujours quand on passe à table » : évaluer un projet dans un centre de secours, le faire adopter, et animer un atelier « repas de garde »	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 9 porte sur la dernière partie de la démarche de projet : **évaluer** et **valoriser**. Le jury vérifie que le candidat sait construire et calculer des indicateurs de processus et de résultat avec les bons dénominateurs, comparer chaque résultat à l'état initial et à la valeur cible, analyser des réponses **appariées** (tableau de transition, progression individuelle), utiliser un test simple ou un groupe de comparaison **sans conclure trop vite**, exploiter un indicateur indirect et des données qualitatives, juger le projet selon des critères explicites (OCDE 2019, RE-AIM), intégrer l'**équité**, analyser le budget réalisé et les règles du financeur, puis **restituer** et **valoriser** auprès de chaque destinataire, participants compris. Il valorise la règle des quatre temps (constater, comparer, expliquer, nuancer), la place donnée aux limites et aux effets inattendus, et la capacité à transformer l'évaluation en décisions. Il pénalise les conclusions affirmatives (« le projet a fait baisser le surpoids »), les pourcentages calculés sur des groupes différents avant et après, et une valorisation réduite à une affiche.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; repérer pour chaque objectif sa valeur initiale, sa cible et sa source ; vérifier qui a répondu avant, après et aux deux temps. Pendant : pour chaque indicateur, écrire la formule, le calcul posé, le résultat avec l'effectif (9 sur 12) et une phrase d'interprétation en quatre temps ; donner un jugement objectif par objectif ; ne jamais présenter un test significatif comme une preuve ; signaler les perdus de vue et les biais. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus

tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Avant, je cuisinais pour toute la famille ; ici, je mange du pain et du fromage » : évaluer et valoriser un projet dans une résidence sociale pour travailleurs migrants âgés

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E4 (dossier de projet : évaluation et bilan) et E5.A (étude de cas en santé publique, exploitation de données).

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année à la résidence sociale « Les Platanes » (structure et territoire fictifs), issue de la transformation d'un ancien foyer de travailleurs migrants. Elle loge 142 personnes dans des studios, dont 96 hommes de 60 ans et plus, arrivés en France pour travailler dans les années 1960 à 1980 et restés seuls après leur retraite. De septembre 2027 à janvier 2028, la résidence a mené le projet « La table des anciens » : dix ateliers de cuisine, un repas partagé chaque semaine et des sorties accompagnées au marché. Le projet est terminé. La responsable de la résidence vous demande d'en **évaluer les résultats**, de rédiger le **bilan** pour les financeurs et de proposer un plan de **valorisation**. Elle vous prévient : « Les financeurs veulent des chiffres, mais les résidents veulent surtout savoir si on continue. »

Document 1 – Le projet tel qu'il a été conçu (extraits de la fiche projet, juin 2027)

- **Constats du diagnostic** (avril 2027, entretiens avec 31 résidents de 60 ans et plus) : 19 ne prennent un repas chaud que deux soirs par semaine ou moins ; 22 disent manger seuls tous les soirs ; 14 ont un diabète connu ; les cuisines collectives d'étage sont peu utilisées (« trop sales », « on ne se connaît plus ») ; 41 des 96 résidents de 60 ans et plus ne lisent pas le français.
- **Objectif général** : contribuer à prévenir la perte d'autonomie liée à l'alimentation chez les résidents de 60 ans et plus.
- **Objectifs spécifiques** (fin janvier 2028, mesurés chez les participants présents au premier et au dernier atelier) : OS1 – au moins 60 % des participants prennent un repas chaud au moins cinq soirs sur sept ; OS2 – au moins 50 % consomment au moins deux portions de légumes par jour ; OS3 – le score moyen au questionnaire de connaissances (sur 10) progresse d'au moins 2 points.
- **Objectifs opérationnels** : réaliser 10 ateliers de cuisine de 2 h 30 pour 22 inscrits ; organiser 20 repas partagés ; organiser 16 sorties au marché ; obtenir un taux de présence aux ateliers d'au moins 75 %.
- **Partenaires** : une diététicienne libérale ; une médiatrice-interprète (arabe et tamazight) ; une association de bénévoles ; le centre communal d'action sociale (minibus) ; le bailleur gestionnaire de la résidence.

Document 2 – Données de processus (émargements et carnet de bord)

Présences aux 10 ateliers (22 inscrits) : 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 18 ; 16 ; 15 ; 17 ; 16 ; 18.

Nombre d'ateliers suivis par inscrit	10	9	8	7	6	5	4
Nombre d'inscrits	4	6	5	2	2	2	1

- Repas partagés : 20 réalisés sur 20 prévus ; 14 convives en moyenne.
- Sorties au marché : 12 réalisées sur 16 prévues (4 annulées : panne du minibus et forte chaleur).
- Profil des 22 inscrits : 14 vivent seuls sans visite régulière de leur famille (70 des 96 résidents de 60 ans et plus sont dans ce cas) ; 9 ne lisent pas le français ; âge médian 74 ans.
- Carnet de bord : baisse de présence aux ateliers 6 et 7 (période de fêtes religieuses et voyages au pays) ; deux ateliers animés sans interprète, un résident bilingue ayant traduit.

Document 3 – Questionnaire avant et après (18 participants présents au 1er et au 10e atelier, réponses appariées par code anonyme)

Questionnaire oral, passé en entretien par la médiatrice-interprète avec des images.

Repas chaud au moins cinq soirs sur sept

Avant ↓ / Après →	Oui	Non	Total avant
Oui	5	1	6
Non	8	4	12
Total après	13	5	18

Au moins deux portions de légumes par jour

Avant ↓ / Après →	Oui	Non	Total avant
Oui	4	1	5
Non	6	7	13
Total après	10	8	18

Document 4 – Scores au questionnaire de connaissances (sur 10), mêmes 18 participants

Code	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18
Avant	3	4	2	5	6	3	4	5	2	3	6	4	5	3	4	7	2	4
Après	6	6	5	7	7	5	6	8	4	6	7	6	7	4	6	8	3	7

Document 5 – Budget prévu et réalisé, financements (données fictives)

Poste	Prévu (€)	Réalisé (€)
Diététicienne libérale (10 ateliers × 3 h × 48 €)	1 440	1 440
Médiatrice-interprète	840	700
Denrées des ateliers	720	600
Denrées des repas partagés	1 200	1 200
Minibus (location et carburant)	720	540
Petit matériel de cuisine	820	820
Supports imagés et traduits	380	380
Évaluation (passation des questionnaires, saisie)	400	400
Fête de restitution	380	400
Total des charges monétaires	**6 900**	**6 480**

Contributions volontaires en nature réalisées : 120 heures de bénévolat valorisées à 13 € de l'heure ; salle commune, 30 utilisations valorisées à 30 €.

Financements reçus : conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, 3 500 € ; caisse de retraite, 1 200 € ; bailleur gestionnaire, 1 000 € ; le reste en fonds propres. La convention avec la conférence des financeurs précise que sa subvention ne peut pas dépasser **52 % des charges monétaires réalisées** ; la part excédentaire doit être reversée.

Document 6 – Un groupe de comparaison (données fictives)

Une résidence sociale voisine, gérée par le même bailleur, n'a pas mené de projet. La médiatrice y a interrogé, aux mêmes dates et avec le même questionnaire, 20 résidents de 60 ans et plus volontaires. Repas chaud au moins cinq soirs sur sept : 7 sur 20 en septembre 2027, 8 sur 20 en janvier 2028. Dans cette résidence, les cuisines d'étage ont été rénovées en 2026.

Document 7 – Paroles recueillies (entretiens de fin de projet avec 8 participants, carnet de bord)

« Avant, je cuisinais pour toute la famille ; ici, je mange du pain et du fromage. Maintenant, le mardi, je fais la chorba avec Ahmed. » « Le marché, c'était bien, mais le minibus ne venait pas toujours. » « La dame parlait de sucre tout le temps. J'ai le diabète, je sais. Moi je voulais apprendre à faire les légumes au four. » « On mange ensemble, on parle du pays. Je suis moins triste le soir. » « Les fiches avec les dessins, je les ai gardées. » « Mon voisin ne vient pas, il a honte de ne pas savoir cuisiner. » Carnet de bord : deux résidents ont nettoyé et réorganisé la cuisine du 2e étage ; le bailleur a installé un deuxième réfrigérateur.

Document 8 – Repères utiles (données réelles)

- Critères d'évaluation du comité d'aide au développement de l'OCDE (révisés en 2019) : pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact, viabilité (durabilité).
- Modèle RE-AIM (Glasgow, Vogt et Boles, 1999) : portée, efficacité, adoption, mise en œuvre, maintien.
- Gain normalisé = (moyenne après − moyenne avant) / (score maximal − moyenne avant).
- Test de McNemar avec correction de continuité, pour des réponses binaires appariées : $\chi^2 = (|b - c| - 1)^2 / (b + c)$, où b et c sont les effectifs des deux cases de changement ; on conclut à un changement significatif au risque de 5 % si $\chi^2 > 3{,}84$. Le test est peu fiable quand b + c est inférieur à 10.
- Intervalle de confiance du risque relatif : $\exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{(1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d))})$.
- Conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées : instituées par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; elles financent des actions de prévention pour les personnes de 60 ans et plus.
- Compte rendu financier de subvention : formulaire Cerfa n° 15059, à transmettre dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, article 10).

Travail à faire

Partie A – Le projet d'intervention : évaluation et bilan (dossier écrit de 10 pages au plus) – C3.1 (9 points)

1. Calculez les indicateurs de processus : taux de réalisation de chaque activité, taux de présence aux ateliers, taux de fidélisation (inscrits ayant suivi au moins 7 ateliers), taux de couverture du public cible. Vérifiez la cohérence des documents 2 et 3. Interprétez. (1,5 pt)

2. Exploitez les tableaux de transition du document 3 : pourcentages avant et après, évolution en points, part des participants qui ont progressé parmi ceux qui pouvaient progresser. Jugez l'atteinte de OS1 et OS2 (taux d'atteinte), en appliquant la règle des quatre temps. (2 pts)

3. Exploitez les scores du document 4 : moyennes, médianes, progression moyenne, gain normalisé ; comparez la progression des participants qui avaient au plus 3 sur 10 au départ à celle des autres. Jugez OS3 et expliquez la prudence nécessaire. (1,5 pt)

4. Analysez le budget : écart entre prévu et réalisé (en euros et en pourcentage), causes des écarts, total du projet avec les contributions en nature, coût par participant et coût par participant ayant atteint OS1. Vérifiez la règle de la convention et calculez l'éventuel reversement. (1,5 pt)

5. Évaluez l'équité du projet (couverture des résidents les plus isolés et des résidents qui ne lisent pas le français). Rédigez un jugement argumenté selon les six critères de l'OCDE et les cinq dimensions de RE-AIM, en utilisant aussi les paroles du document 7. (2,5 pts)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée – C3.3 (3 points)

6. Appliquez le test de McNemar aux deux tableaux du document 3. Interprétez chaque résultat et expliquez pourquoi le second n'est pas significatif alors que la part de participants a presque doublé. (1,5 pt)

7. Exploitez le document 6 : différence des évolutions en points entre les deux résidences, risque relatif en fin de projet et son intervalle de confiance à 95 %. Discutez la comparabilité des deux groupes et proposez un protocole plus solide pour la prochaine édition. (1,5 pt)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

8. Organisez une veille sur l'évaluation des actions de prévention en nutrition auprès des personnes âgées immigrées : sources (au moins quatre, dont une base d'interventions probantes et un portail de capitalisation), outils, fréquence, partage dans l'équipe. (2 pts)

Partie D – Communication et posture professionnelle – C3.5 et C3.6 (3 points)

9. Élaborez le plan de valorisation du projet pour cinq destinataires (résidents, équipe et bailleur, financeurs, professionnels, élus), avec le support, le message clé et le calendrier. Indiquez les précautions éthiques pour l'usage des paroles et des photos des résidents. (1,5 pt)

10. Rédigez la trame minutée de votre exposé de 10 minutes et listez 12 questions probables du jury, avec les éléments de réponse attendus pour quatre d'entre elles. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Ma gamelle, c'est moi qui la fais » : un atelier culinaire pour des travailleurs d'un ESAT, et son évaluation

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des sujets U62 et E5.B (bon de commande, mise à l'échelle et rendement, fiche technique, organisation dans le temps, hygiène) et du BTS blanc CNED E5B (calcul nutritionnel). La partie évaluation est renforcée, en lien avec le chapitre 9.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'établissement et service d'accompagnement par le travail (ESAT) « Les Ateliers du Moulin » (structure fictive) emploie 48 travailleurs en situation de handicap, principalement avec une déficience intellectuelle, dans des ateliers de conditionnement, d'espaces verts et de blanchisserie. L'ESAT n'a pas de restaurant : chacun apporte son déjeuner ou l'achète à la boulangerie voisine. Le moniteur principal constate : « Beaucoup arrivent avec un paquet de chips et un soda, ou rien du tout. Ceux qui vivent en appartement seuls ne savent pas quoi préparer. » Dans le cadre d'un projet « Bien manger au travail », vous concevez et animez un atelier où les travailleurs préparent **leur propre déjeuner à emporter pour le lendemain**, puis vous proposez la manière d'**évaluer** l'atelier et ses effets.

Document 1 – Le public et les contraintes

- 8 travailleurs volontaires de 24 à 52 ans ; on prévoit 12 portions (participants, le moniteur, l'éducatrice qui co-anime, vous et une portion de démonstration).
- Monsieur B., 34 ans, porteur de trisomie 21, en surpoids ; il boit environ un litre de soda par jour.
- Madame C., 28 ans, ne lit pas ; elle reconnaît bien les images et les couleurs ; elle a une épilepsie stabilisée par un traitement.
- Madame E., 31 ans, a une allergie à l'arachide ; elle porte sur elle un stylo d'adrénaline.
- Monsieur F., 40 ans, est végétarien.
- Madame G., 45 ans, a une faiblesse de la main gauche après un accident vasculaire cérébral.
- Monsieur H., 52 ans, a un diabète de type 2 traité par comprimés.
- Quatre participants vivent seuls en appartement avec l'accompagnement d'un service d'accompagnement à la vie sociale ; deux vivent en foyer d'hébergement ; deux vivent chez leurs parents.
- Salle de réunion de l'ESAT aménagée : deux plaques à induction, un four, un réfrigérateur, un évier, deux tables ; 12 boîtes hermétiques et 8 sacs isothermes avec pains de glace achetés par le projet.
- Budget denrées : au plus 2,80 € par portion.
- Durée de l'atelier avec les participants : 2 h, de 13 h 30 à 15 h 30, sur le temps de travail ; le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 2 – Menu imposé : le déjeuner à emporter

Salade de pâtes complètes au thon, haricots verts, tomates cerises, maïs et oignon rouge, vinaigrette à l'huile de colza et à la moutarde.

Yaourt nature.

Barre maison aux flocons d'avoine, à la banane et aux raisins secs (sans sucre ajouté).

Clémentine.

Le candidat réalise la salade, la vinaigrette et les barres. Il présente une version végétarienne (pois chiches à la place du thon), les adaptations pour Monsieur B., Madame C., Madame E., Madame G. et Monsieur H., et les règles pour transporter et conserver le déjeuner jusqu'au lendemain midi.

Document 3 – Grammages nets par portion, pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Pâtes sèches au blé complet	70 g (poids cru)	sans perte	2,20 € le kg
Thon au naturel, égoutté	60 g	sans perte (prix du poids égoutté)	16,00 € le kg
Haricots verts frais	60 g	10 %	4,20 € le kg
Tomates cerises	60 g	5 %	6,50 € le kg
Maïs doux en conserve, égoutté	20 g	sans perte	4,00 € le kg
Oignon rouge	10 g	10 %	2,80 € le kg
Huile de colza (vinaigrette 8 g, barre 2,5 g)	10,5 g	sans perte	3,20 € le kg
Vinaigre de vin	4 g	sans perte	1,50 € le kg
Moutarde	2 g	sans perte	4,00 € le kg
Yaourt nature	125 g	sans perte	1,60 € le kg
Flocons d'avoine	25 g	sans perte	2,40 € le kg
Banane	20 g	35 %	2,00 € le kg
Raisins secs	8 g	sans perte	8,00 € le kg
Clémentine	70 g	25 %	3,20 € le kg
Pois chiches en conserve, égouttés (version végétarienne)	80 g	sans perte	2,60 € le kg
Herbes, sel, poivre	–	–	forfait 0,60 € pour l'atelier

Quantité brute = quantité nette / (1 – taux de perte).

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Pâtes sèches, au blé complet, crues (9870)	353	11,8	67,6	1,8	2,2	6,1	0,016	32,1	3,2	0
Thon, au naturel, appertisé, égoutté (26039)	143	26,8	0	0	3,94	0	0,74	6,26	0,76	traces
Haricot vert, cru (20061)	31,9	1,83	4,14	3,26	0,22	2,7	0,015	37	1,03	12,2
Tomate cerise, crue (20172)	31,8	1,31	5,62	4,8	< 0,5	1,2	< 0,013	6,6	0,37	21,8

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Maïs doux, appertisé, égoutté (20066)	105	2,66	18,3	2,37	1,68	3,1	0,59	3,51	0,35	2,1
Oignon rouge, cru (20238)	35	1,31	5,63	5,2	0,4	2,5	< 0,013	22	0,19	4,09
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0,023	0
Vinaigre (11018)	22,5	0,04	0,95	0,04	0,1	0	0,013	6	0,24	0,5
Moutarde (11013)	151	6,92	4,33	1,73	11,2	< 1	6,3	207	2,64	–
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	3,83	4,26	4	1,68	traces	0,1	137	< 0,25	< 2
Flocons d'avoine (32140)	369	10,6	57,7	1,04	7,82	11,2	0,011	52	3,8	0
Banane, chair sans peau, crue (13005)	87,6	1,06	19,7	15,6	< 0,5	2,7	< 0,013	5,1	0,2	7,16
Raisin sec (13046)	322	3	73,2	70,3	0,9	4,2	0,013	54	1,7	< 0,5
Clémentine ou mandarine, chair sans peau, sans pépins, crue (13024)	45,5	0,81	9,17	8,6	< 0,5	1,7	< 0,013	23	0,09	49,2
Pois chiche, appertisé, égoutté (20532)	122	6,74	15	0,5	2,68	5,45	0,54	41,2	1,15	0,1
Barre céréalière aux fruits (31113)	379	5,49	74,1	29,6	7,07	3,8	0,63	84	2,18	0

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < », « traces » ou « – » est comptée 0. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 5 – Ce qu'il y avait dans les déjeuners (observation, données fictives)

Avec l'accord des travailleurs, le moniteur a noté pendant 4 jours, avant le projet, le contenu des déjeuners des 8 participants (32 déjeuners observés) : 9 déjeuners contenaient au moins un légume ; 14 contenaient une boisson sucrée ; 6 se limitaient à un produit de grignotage (chips, biscuits) ; 3 fois, le participant n'avait rien apporté.

Document 6 – Grille d'observation remplie par l'éducatrice pendant l'atelier (8 participants)

Compétence observée	Fait seul	Fait avec aide	Pas fait
Se laver les mains au bon moment	6	2	0
Égoutter le thon ou les pois chiches	7	1	0

Compétence observée	Fait seul	Fait avec aide	Pas fait
Peser ou mesurer un ingrédient avec un verre doseur imagé	4	3	1
Assembler sa salade dans la boîte	8	0	0
Écrire ou coller l'étiquette (nom, date)	3	4	1
Ranger sa boîte au réfrigérateur	8	0	0

Échelle de satisfaction en fin d'atelier (trois visages) : 7 visages souriants, 1 visage neutre, 0 visage triste.

Document 7 – Repères utiles (données réelles)

- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des féculents complets au moins une fois par jour ; des produits laitiers deux fois par jour ; l'eau est la seule boisson indispensable ; limiter les boissons sucrées.
- Anses (références nutritionnelles, 2016 et 2021) : apport satisfaisant en fibres de 30 g par jour pour l'adulte ; calcium 950 mg par jour à partir de 25 ans ; vitamine C 110 mg par jour.
- Règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) : 14 allergènes à signaler, dont l'arachide, les céréales contenant du gluten, le lait, le poisson, la moutarde et les sulfites.
- Arrêté du 21 décembre 2009 : denrées très périssables conservées au froid positif ; refroidissement rapide des préparations cuites (de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures).
- Code de l'action sociale et des familles, article L. 344-2 : les ESAT accueillent des personnes handicapées dont la capacité de travail ne leur permet pas de travailler dans une entreprise ordinaire, et leur proposent un soutien médico-social et éducatif.
- Facile à lire et à comprendre (FALC) : règles européennes établies par l'association Inclusion Europe ; phrases courtes, un message par phrase, images, relecture par des personnes concernées.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Exploitez le document 5 (pourcentages) et dégagez trois besoins. Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier, observables pendant la séance. (1,5 pt)
2. Établissez le bon de commande pour 12 portions (quantités nettes, brutes, coût) ; calculez le coût par portion, l'effet de la version végétarienne pour une portion, et vérifiez le budget ; identifiez le poste le plus coûteux. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique de la salade, de la vinaigrette et des barres, sous la forme d'une fiche recette accessible (étapes illustrées, une action par étape). Présentez les adaptations pour Monsieur B., Madame C., Madame E., Monsieur F., Madame G. et Monsieur H. (3 pts)
4. Calculez l'apport d'une portion du déjeuner complet (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer, vitamine C) et la répartition de l'énergie ; calculez l'apport de la version végétarienne. Comparez la barre maison à une barre céréalière aux fruits du commerce de 25 g, par portion et pour 100 g. Commentez au regard des repères. (2 pts)
5. Rédigez les règles de préparation, de refroidissement, de transport et de conservation du déjeuner jusqu'au lendemain midi. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et participants), avec des tâches adaptées à chacun. (2 pts)
7. Présentez les méthodes d'animation et les outils (démonstration, binômes, recette imagée, verre doseur imagé, étiquettes à coller), la façon d'aborder les boissons sucrées sans culpabiliser, et la gestion du risque d'allergie. (1,5 pt)

8. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité de l'atelier et trois éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez la salade (une version au thon, une version végétarienne), la vinaigrette et les barres ; conditionnez deux déjeuners complets étiquetés. (2,5 pts)

10. Exploitez les documents 5 et 6 : pourcentages de réussite par compétence, compétences à retravailler, lecture de l'échelle de satisfaction et ses limites. Proposez le plan d'évaluation des effets de l'atelier à un mois (indicateurs, outils adaptés au public, consentement, comparaison avec le document 5). (2,5 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Le bip sonne toujours quand on passe à table » : évaluer un projet dans un centre de secours, le faire adopter, et animer un atelier « repas de garde »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet de synthèse – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2)

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Temps 1 : préparation conseillée 3 h, puis 30 min d'oral blanc · Temps 2 : 3 h · Barème : 20 points pour chaque temps. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E4 (bilan et évaluation d'un projet), E5.A et E5.B (atelier culinaire, bon de commande, calcul nutritionnel).

Mise en situation – Mise en situation

Le centre d'incendie et de secours de Valcourt (structure fictive) compte 64 sapeurs-pompiers professionnels qui assurent des gardes de 24 heures, par équipes de 12. Pendant la garde, l'équipe cuisine ses repas à la caserne, avec une caisse commune alimentée par les agents (la « popote »). Après une visite de médecine professionnelle qui a montré une prise de poids fréquente et des collations nocturnes très sucrées, le service de santé et de secours médical du département et l'amicale des sapeurs-pompiers ont mené de septembre 2027 à février 2028 le projet « Popote en forme » : formation de quatre agents référents, carnet de menus de garde, achats groupés, collation de nuit préparée à l'avance. Vous arrivez en stage en mars 2028. Le médecin-chef vous demande l'**évaluation finale** du projet et une proposition pour le **présenter aux onze autres centres** du groupement ; vous animerez aussi un atelier pour les agents.

Temps 1 – L'évaluation finale et la valorisation du projet

Document 1 – Le projet prévu (fiche projet, juillet 2027)

- **Objectif spécifique 1** : en février 2028, réduire d'un tiers au moins la part des agents qui prennent une collation sucrée ou grasse pendant la nuit de garde.
- **Objectif spécifique 2** : augmenter d'au moins 50 % la part des fruits et légumes dans les achats de la popote, sans augmenter le coût par repas.
- **Objectifs opérationnels** : former 4 référents ; diffuser un carnet de 20 menus de garde ; organiser les achats groupés chaque semaine ; atteindre 80 % des équipes de garde qui utilisent le carnet au moins une fois par garde.
- **Budget** : 9 800 € (formation des référents, carnet, matériel de conservation, temps de diététicienne), dont 1 400 € consacrés à l'évaluation (questionnaires, groupes de discussion, analyse des tickets d'achat).

Document 2 – Les achats de la popote (relevé des tickets, 8 semaines avant le projet et 8 semaines en fin de projet, en euros ; 1 344 repas servis dans chaque période)

Catégorie	Avant (sept.-oct. 2027)	Fin de projet (janv.-févr. 2028)
Fruits et légumes	412	690
Féculents (pain, pâtes, riz, pommes de terre)	186	240
Légumes secs	0	96
Viandes et charcuteries	798	610
Produits laitiers	214	236
Boissons sucrées	236	128
Biscuits et confiseries	318	196

Catégorie	Avant (sept.-oct. 2027)	Fin de projet (janv.-févr. 2028)
Plats préparés	402	188

Document 3 – Questionnaire des agents (données fictives)

Questionnaire anonyme avec un code personnel, en septembre 2027 (58 répondants sur 64) et en février 2028 (49 répondants) ; 44 agents ont répondu aux deux.

Collation sucrée ou grasse pendant la nuit de garde (44 agents, réponses appariées)

Septembre ↓ / Février →	Oui	Non	Total septembre
Oui	15	14	29
Non	3	12	15
Total février	18	26	44

Note moyenne de satisfaction sur les repas de garde (sur 10) : 5,8 en septembre, 7,1 en février.

Utilisation du carnet de menus au moins une fois par garde : 41 gardes sur 56 relevées en février par les référents.

Document 4 – Groupes de discussion (deux groupes de 7 agents, février 2028) : nombre de mentions par thème après codage

Thème	Mentions	Exemple de verbatim
Départs en intervention pendant la préparation ou le repas	11	« Le bip sonne toujours quand on passe à table. On revient deux heures après, tout est froid ou trop cuit. »
Convivialité du repas de garde	9	« Le repas, c'est le moment où l'équipe se retrouve. »
Goût des nouveaux plats	8	« Le chili sans viande, je n'y croyais pas, et j'en ai repris. »
Sommeil et collation de nuit	7	« La boîte de nuit préparée à l'avance, ça évite le paquet de gâteaux à 3 heures. »
Coût de la popote	6	« On paie moins cher qu'avant, c'est surprenant. »
« Un pompier, ça mange de la viande »	5	« Les anciens râlent quand il n'y a pas de viande. »

Document 5 – Diffusion dans le groupement (mars 2028)

Sur les 11 autres centres du groupement, 4 ont demandé le carnet de menus, 2 ont désigné un référent popote. Le médecin-chef souhaite une présentation au comité de direction du groupement en avril.

Document 6 – Repères utiles (données réelles)

- Critères d'évaluation de l'OCDE (2019) : pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact, viabilité.
- Modèle RE-AIM (Glasgow, Vogt et Boles, 1999) : portée, efficacité, adoption, mise en œuvre, maintien.
- Grille ASTAIRE (Cambon et coll., 2013) : outil d'analyse de la transférabilité d'une intervention en promotion de la santé (population, environnement, mise en œuvre, accompagnement du transfert).
- Test de McNemar avec correction de continuité : $\chi^2 = (|b - c| - 1)^2 / (b + c)$; changement significatif au risque de 5 % si $\chi^2 > 3{,}84$.

- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour, des légumes secs au moins deux fois par semaine, limiter la charcuterie à 150 g par semaine et les viandes autres que la volaille à 500 g par semaine.

Travail à faire – Temps 1

Partie A – Le projet d'intervention : évaluation finale – C3.1 (9 points)

1. Calculez les taux de réponse du document 3 et le taux d'utilisation du carnet. Jugez les objectifs opérationnels. (1 pt)
2. Exploitez le document 2 : totaux, coût par repas, part de chaque catégorie dans les achats, évolution en euros et en pourcentage. Jugez l'objectif spécifique 2 (augmentation relative de la part des fruits et légumes, coût par repas). Expliquez pourquoi les tickets d'achat sont un indicateur indirect, avec ses avantages et ses limites. (2,5 pts)
3. Exploitez le tableau de transition du document 3 et jugez l'objectif spécifique 1 (réduction relative de la part des agents concernés). (1,5 pt)
4. Exploitez le document 4 : part de chaque thème dans les mentions ; tirez trois enseignements pour la suite du projet, dont un sur les départs en intervention. (1,5 pt)
5. Rédigez le jugement évaluatif selon les six critères de l'OCDE ; discutez la part du budget consacrée à l'évaluation (proportionnalité). (2,5 pts)

Partie B – Recherche appliquée – C3.3 (3 points)

6. Appliquez le test de McNemar au tableau du document 3 et interprétez. Citez trois biais qui peuvent affecter ce résultat et la façon de les limiter. (1,5 pt)
7. Analysez la transférabilité du projet aux onze autres centres avec les dimensions de la grille ASTAIRE et le volet « adoption » de RE-AIM (document 5) : fonctions clés à conserver, éléments adaptables, conditions de réussite. (1,5 pt)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

8. Organisez une veille sur l'alimentation et le travail posté de nuit, et sur les expériences de prévention dans les services d'incendie et de secours (sources, outils, fréquence, diffusion aux référents). (2 pts)

Partie D – Communication et posture – C3.5 et C3.6 (3 points)

9. Construisez la présentation de 10 minutes au comité de direction du groupement (plan, trois chiffres clés, un graphique, une recommandation) et une fiche de capitalisation d'une page. Comment répondez-vous au thème « un pompier, ça mange de la viande » sans opposer les agents ? (1,5 pt)
10. Rédigez la trame minutée de votre exposé au jury et cinq questions probables avec les éléments de réponse. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale (3 points)

Temps 2 – L'atelier « repas de garde qui supporte le bip »

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'atelier a lieu dans la cuisine de la caserne, de 10 h à 12 h, avec l'équipe de garde (10 agents, dont les 2 référents popote) ; on prévoit 12 portions. L'objectif est de préparer un **déjeuner de garde complet qui supporte une interruption** : si l'équipe part en intervention, le plat doit pouvoir être maintenu au chaud ou refroidi puis réchauffé sans risque et sans perdre son goût. L'équipe peut partir à tout moment : l'atelier doit être organisé pour qu'un départ ne mette en danger ni les agents ni la sécurité des aliments.

Document 7 – Le public et les contraintes

- 10 agents de 23 à 54 ans, dont une femme ; activité physique importante (entraînement quotidien, interventions).

- Monsieur A., 46 ans, a une hypertension artérielle traitée ; son médecin lui a conseillé de limiter le sel.
- Monsieur D., 29 ans, ne mange pas de porc.
- Madame K., 31 ans, a une intolérance au lactose diagnostiquée.
- Monsieur L., 52 ans, est l'un des « anciens » qui trouvent que « la popote n'est plus ce qu'elle était ».
- Cuisine de la caserne : piano à 4 feux, four mixte, cellule de refroidissement rapide, réfrigérateurs, thermomètre à sonde, bacs gastronormes.
- Budget de la popote : au plus 3,50 € par portion.

Document 8 – Menu imposé

Salade de chou rouge, vinaigrette à l'huile de colza.

Émincé de poulet basquaise (poivrons, oignons, tomates, ail, paprika, huile d'olive), riz complet.

Fromage blanc aux framboises.

Le candidat réalise les trois préparations et présente l'organisation qui permet de **maintenir le plat au chaud** ou de le **refroidir rapidement puis le réchauffer** en cas de départ.

Document 9 – Grammages nets par portion, pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Filets de poulet	120 g	sans perte	10,90 € le kg
Poivrons rouges	80 g	20 %	3,50 € le kg
Oignons	30 g	10 %	1,80 € le kg
Tomates pelées en conserve, avec le jus	80 g	sans perte	1,90 € le kg
Ail	2 g	15 %	8,00 € le kg
Huile d'olive	6 g	sans perte	9,50 € le kg
Riz complet	80 g (poids cru)	sans perte	2,60 € le kg
Chou rouge	80 g	20 %	1,60 € le kg
Huile de colza	6 g	sans perte	3,20 € le kg
Vinaigre	3 g	sans perte	1,50 € le kg
Fromage blanc 3 % de matière grasse	100 g	sans perte	2,60 € le kg
Framboises surgelées	50 g	sans perte	7,90 € le kg
Paprika, sel, poivre, herbes	–	–	forfait 0,80 € pour l'atelier

Document 10 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Poulet, filet sans peau cru (36017)	110	23,4	0	traces	1,5	0	0,11	3,3	0,33	4,89
Poivron rouge, cru (20087)	33,6	1,06	5,98	4,8	< 0,5	3,2	< 0,013	4,8	0,21	121
Oignon, cru (20034)	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098	25	0,00019	3,9
Tomate, pelée, appertisée, au jus, non égouttée (20137)	21,8	0,79	3,15	2,55	0,25	1,9	0,025	33	0,57	12,6

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Ail, cru (11000)	109	5,31	18,6	1,2	< 0,5	5,8	0,023	11	0,63	< 0,5
Huile d'olive vierge extra (17270)	899	0,25	traces	0	99,9	0	< 0,013	< 0,2	< 0,05	0
Paprika, poudre (11049)	318	14,1	18,8	10,3	12,9	34,9	0,17	229	21,1	0,9
Riz complet, cru (9102)	350	7,02	71,4	0	2,8	5	0,01	11,1	< 1	0
Chou rouge, cru (20014)	26,4	1,13	4,33	3,9	< 0,5	2,8	0,035	36	0,25	18,7
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0,023	0
Vinaigre (11018)	22,5	0,04	0,95	0,04	0,1	0	0,013	6	0,24	0,5
Fromage blanc, nature, 2-3% MG (19646)	75,7	7,28	3,86	3,86	3,23	0,019	0,088	131	< 0,25	< 2
Framboise, crue (13015)	47,9	1,19	5,83	5,4	0,8	4,3	< 0,013	16	0,4	18,7

On calcule avec les poids nets crus ; pour les framboises surgelées, on utilise la valeur de la framboise crue. On compte 0,5 g de paprika par portion ; le sel ajouté n'est pas compté. Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 11 – Deux situations qui pourraient se présenter pendant l'atelier

À 11 h 05, alors que le poulet vient d'être saisi et que le riz cuit, l'équipe part en intervention ; elle revient à 13 h 20. Pendant la dégustation, Monsieur L. déclare devant tout le monde : « C'est bien joli, mais un vrai repas de pompier, c'est une côte de bœuf et des frites. »

Travail à faire – Temps 2

Partie 1 – Conception (11 points)

11. Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier, observables à la fin de la séance. (1,5 pt)

12. Établissez le bon de commande pour 12 portions ; calculez le coût par portion, vérifiez le budget et identifiez le poste le plus coûteux. (2 pts)

13. Rédigez la fiche technique des trois préparations, avec les points critiques et les adaptations pour Monsieur A., Monsieur D. et Madame K. (3 pts)

14. Calculez l'apport d'une portion du repas (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer, vitamine C) et la répartition de l'énergie ; commentez au regard des repères et du public. (2,5 pts)

15. Rédigez la procédure « départ en intervention » : maintien au chaud, refroidissement rapide, réchauffage, ce qu'on jette. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

16. Présentez le déroulé minuté des 3 heures, en prévoyant les points d'arrêt possibles. (2 pts)

17. Présentez les méthodes d'animation qui associent les référents et les « anciens », et une grille de dégustation. (1,5 pt)

18. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité (volaille, couteaux, feux laissés sans surveillance) et deux éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

19. Réalisez les trois préparations ; dressez une assiette standard et une assiette adaptée à Madame K. (3 pts)

20. Proposez l'évaluation de l'atelier et analysez les deux situations du document 11, avec la réponse que vous donnez. (1 pt)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Avant, je cuisinais pour toute la famille ; ici, je mange du pain et du fromage » : évaluer et valoriser un projet dans une résidence sociale pour travailleurs migrants âgés

que le jury attend

Le jury évalue la capacité à juger un projet terminé avec rigueur : calculer les bons indicateurs avec les bons dénominateurs, comparer chaque résultat à l'objectif et à l'état initial, analyser les réponses appariées, mobiliser un test simple sans en exagérer la portée, intégrer l'équité et les données qualitatives, puis transformer l'évaluation en décisions et en supports de valorisation adaptés à chaque destinataire. Il valorise la prudence (petit effectif, données déclaratives, groupe de comparaison imparfait), le respect des règles du financeur et la place donnée aux résidents dans la restitution. Il pénalise les pourcentages calculés sur 22 alors que 18 personnes ont répondu deux fois, un « test significatif » présenté comme une preuve, et un bilan sans limites ni perspectives.

Partie A – Le projet d'intervention : évaluation et bilan

Question 1 – Indicateurs de processus (1,5 pt)

Calcul posé – Réalisation, présence, fidélisation, couverture

- Ateliers : 10 / 10 × 100 = **100 %** ; repas partagés : 20 / 20 × 100 = **100 %** ; sorties au marché : 12 / 16 × 100 = **75 %**.
- Présences : 20 + 19 + 18 + 17 + 18 + 16 + 15 + 17 + 16 + 18 = **174** ; présences possibles : 10 × 22 = 220 ; taux de présence : 174 / 220 × 100 = **79,1 %** (cible 75 % : atteinte).
- Fidélisation : inscrits ayant suivi au moins 7 ateliers = 4 + 6 + 5 + 2 = **17** ; 17 / 22 × 100 = **77,3 %**.
- Couverture : 22 inscrits / 96 résidents de 60 ans et plus × 100 = **22,9 %**.
- Cohérence : 4 × 10 + 6 × 9 + 5 × 8 + 2 × 7 + 2 × 6 + 2 × 5 + 1 × 4 = 40 + 54 + 40 + 14 + 12 + 10 + 4 = **174** présences, comme dans la liste des émargements. Le questionnaire « après » a été passé au 10e atelier (18 présents) : 22 − 18 = **4 perdus de vue**.

Interprétation. Le projet a été mis en œuvre presque comme prévu : ateliers et repas réalisés en totalité, présence et fidélisation supérieures à 75 %. Seules les sorties au marché sont en retrait (4 annulations pour des causes extérieures : panne, chaleur), ce qui montre la dépendance à un seul moyen de transport. La baisse aux ateliers 6 et 7 a une cause identifiée (fêtes religieuses, voyages au pays) : il faudra en tenir compte dans le calendrier suivant. La couverture (moins d'un quart du public cible) est un point d'attention : le projet a touché une minorité des résidents âgés, ce que la question 5 analyse.

Question 2 – Tableaux de transition et objectifs OS1 et OS2 (2 pts)

Calcul posé – Repas chaud au moins cinq soirs sur sept (n = 18)

- Avant : 6 / 18 = **33,3 %** ; après : 13 / 18 = **72,2 %** ; évolution : 72,2 − 33,3 = **+ 38,9 points**.
- Stables « oui » : 5 ; progression (non → oui) : **8** ; régression (oui → non) : **1** ; stables « non » : 4.
- Participants qui pouvaient progresser (« non » avant) : 12 ; part ayant progressé : 8 / 12 × 100 = **66,7 %**.
- Taux d'atteinte de OS1 : 72,2 / 60 × 100 = **120,4 %**.

Calcul posé – Au moins deux portions de légumes par jour (n = 18)

- Avant : 5 / 18 = **27,8 %** ; après : 10 / 18 = **55,6 %** ; évolution : **+ 27,8 points**.

- Progression : **6** ; régression : **1** ; stables « oui » : 4 ; stables « non » : 7.
- Part ayant progressé parmi ceux qui pouvaient progresser : 6 / 13 × 100 = **46,2 %**.
- Taux d'atteinte de OS2 : 55,6 / 50 × 100 = **111,1 %**.

Interprétation selon la règle des quatre temps (OS1). *Constater* : la part des participants qui prennent un repas chaud au moins cinq soirs sur sept est passée de 6 à 13 sur 18 (33,3 % à 72,2 %). *Comparer* : l'objectif de 60 % est dépassé (taux d'atteinte de 120,4 %). *Expliquer* : les ateliers ont porté sur des plats simples réalisables dans les cuisines d'étage, les repas partagés ont recréé l'habitude de cuisiner à plusieurs (« le mardi, je fais la chorba avec Ahmed »), et la cuisine du 2e étage a été remise en état par deux résidents. *Nuancer* : les données sont déclaratives, recueillies par la médiatrice que les résidents connaissent (désirabilité sociale) ; elles portent sur 18 personnes, dont on ignore la situation des 4 perdus de vue ; une personne a régressé. OS2 est aussi atteint, mais moins nettement : plus de la moitié de ceux qui pouvaient progresser (7 sur 13) n'ont pas changé leur consommation de légumes.

Question 3 – Scores de connaissances et OS3 (1,5 pt)

Calcul posé – Scores sur 10 (n = 18)

- Somme avant : 3 + 4 + 2 + 5 + 6 + 3 + 4 + 5 + 2 + 3 + 6 + 4 + 5 + 3 + 4 + 7 + 2 + 4 = **72** ; moyenne : 72 / 18 = **4,0**.
- Somme après : 6 + 6 + 5 + 7 + 7 + 5 + 6 + 8 + 4 + 6 + 7 + 6 + 7 + 4 + 6 + 8 + 3 + 7 = **108** ; moyenne : 108 / 18 = **6,0**.
- Médianes : avant **4** (9e et 10e valeurs classées : 4 et 4) ; après **6** (6 et 6).
- Progression moyenne : 6,0 − 4,0 = **+ 2,0 points** ; tous les participants ont progressé (de 1 à 3 points).
- Gain normalisé : (6,0 − 4,0) / (10 − 4,0) = 2 / 6 = **0,33** : un tiers de la marge de progression possible a été gagné.
- Participants à 3 ou moins au départ (P1, P3, P6, P9, P10, P14, P17) : progressions 3 + 3 + 2 + 2 + 3 + 1 + 1 = 15 ; moyenne 15 / 7 = **2,14 points**. Autres (11 participants) : 36 − 15 = 21 ; moyenne 21 / 11 = **1,91 point**.

Jugement. OS3 (progression d'au moins 2 points) est atteint, mais **tout juste** : la moyenne progresse exactement de 2,0 points. Les participants qui partaient de plus bas ont un peu plus progressé, ce qui va dans le sens d'une réduction des écarts. Trois prudences : la différence entre les deux sous-groupes est faible (0,23 point) et porte sur 7 et 11 personnes ; les scores les plus bas ont mécaniquement tendance à remonter au second passage (**régression vers la moyenne**) ; et les participants ont pu retenir les questions du premier passage (effet d'apprentissage). Deux participants ont seulement 3 et 4 sur 10 à la fin : il faut regarder les questions échouées pour adapter les supports.

Question 4 – Budget et efficience (1,5 pt)

Calcul posé – Écarts, coût total et coûts unitaires

- Écart global : 6 480 − 6 900 = **− 420 €**, soit − 420 / 6 900 × 100 = **− 6,1 %** (taux de réalisation du budget : 93,9 %).
- Détail : médiatrice − 140 € (deux ateliers sans interprète) ; denrées des ateliers − 120 € ; minibus − 180 € (quatre sorties annulées) ; fête de restitution + 20 € ; − 140 − 120 − 180 + 20 = **− 420 €**.
- Contributions en nature : bénévolat 120 × 13 = **1 560 €** ; salle 30 × 30 = **900 €** ; total **2 460 €**. Coût total du projet : 6 480 + 2 460 = **8 940 €**.
- Coût monétaire par participant : 6 480 / 22 = **294,55 €** ; coût total par participant : 8 940 / 22 = **406,36 €**.
- Coût monétaire par participant ayant atteint OS1 : 6 480 / 13 = **498,46 €**.
- Règle de la convention : 52 % × 6 480 = **3 369,60 €** ; la conférence des financeurs a versé 3 500 € ; reversement : 3 500 − 3 369,60 = **130,40 €**.
- Financement réel : 3 369,60 + 1 200 + 1 000 = 5 569,60 € ; fonds propres : 6 480 − 5 569,60 = **910,40 €** (au lieu de 780 € avant reversement).

Interprétation. La sous-consommation du budget est faible et s'explique : deux postes reflètent des activités non réalisées (sorties, interprétariat), un autre une économie (légumes donnés). Elle a une conséquence que l'on oublie souvent : comme la subvention est plafonnée à 52 % des charges **réalisées**, l'association doit reverser 130,40 € et l'indiquer dans le compte rendu financier (Cerfa n° 15059). Le coût par participant (294,55 € en dépenses monétaires pour cinq mois d'accompagnement, dix ateliers et vingt repas) est cohérent avec ce type d'action collective ; il n'a de sens que comparé à d'autres actions ou à l'édition suivante. Les contributions en nature représentent 2 460 / 8 940 × 100 = **27,5 %** du coût total : l'engagement des bénévoles et du bailleur est un résultat en soi.

Question 5 – Équité, critères de l'OCDE et RE-AIM (2,5 pts)

Calcul posé – Équité de la couverture

- Résidents seuls sans visite régulière : 14 inscrits sur 70, soit **20,0 %** ; autres résidents de 60 ans et plus : 8 sur 26, soit **30,8 %**. Rapport des couvertures : 20,0 / 30,8 = **0,65**.
- Résidents qui ne lisent pas le français : 9 parmi les 22 inscrits, soit **40,9 %**, pour 41 sur 96 dans le public cible, soit **42,7 %**. Couverture : 9 / 41 = **22,0 %** contre 13 / 55 = **23,6 %** pour les résidents qui lisent le français.

Lecture. Les supports imagés et la médiatrice-interprète ont permis de toucher les résidents qui ne lisent pas le français presque autant que les autres : c'est une réussite en matière d'équité. En revanche, les résidents les plus isolés ont été **moins touchés** (20 % contre 30,8 %) alors qu'ils étaient la priorité du diagnostic. La parole « mon voisin ne vient pas, il a honte de ne pas savoir cuisiner » donne une piste d'explication : l'atelier de cuisine peut faire peur. Il faudra prévoir d'autres portes d'entrée (repas partagé sans obligation de cuisiner, visite à domicile par un pair, invitation personnelle).

Critère (OCDE, 2019)	Jugement argumenté
Pertinence	Forte : le projet répond aux constats (repas chauds rares, solitude, cuisines inutilisées) et à la priorité de prévention de la perte d'autonomie. Une parole montre une limite : un participant diabétique aurait voulu moins de discours sur le sucre et plus de pratique.
Cohérence	Bonne cohérence interne (actions liées aux objectifs) et externe (financement de la conférence des financeurs, partenariat avec le CCAS et le bailleur).
Efficacité	OS1 et OS2 atteints, OS3 atteint de justesse ; 66,7 % des participants qui pouvaient progresser pour le repas chaud l'ont fait.
Efficience	294,55 € de dépenses monétaires par participant ; ressources bien utilisées (écart de − 6,1 %), avec une part importante de contributions en nature.
Impact	Effets inattendus positifs : cuisine du 2e étage remise en état par des résidents, réfrigérateur installé par le bailleur, sentiment de solitude moindre (« je suis moins triste le soir »). L'impact sur l'autonomie ne peut pas être démontré en cinq mois.
Durabilité (viabilité)	Fragile : le projet dépend de financements annuels, du minibus et de la médiatrice ; des leviers existent (résidents qui cuisinent ensemble le mardi, cuisine rénovée, fiches gardées).

Dimension RE-AIM	Résultat
Portée	22 inscrits sur 96 (22,9 %) ; non-lecteurs bien touchés, résidents isolés moins touchés
Efficacité	Progrès nets sur le repas chaud, plus modérés sur les légumes ; connaissances + 2 points
Adoption	Le bailleur s'est impliqué (réfrigérateur) ; à vérifier : intérêt d'autres résidences du même bailleur

Dimension RE-AIM	Résultat
Mise en œuvre	Fidèle au programme (100 % des ateliers et des repas, 75 % des sorties), avec une adaptation (traduction par un résident)
Maintien	Non mesuré à ce stade : prévoir un recueil à 3 et 6 mois et suivre la fréquentation de la cuisine d'étage

Conclusion du bilan : le projet est pertinent, il a été bien mis en œuvre et il a atteint ses objectifs chez les participants ; il doit maintenant mieux toucher les résidents les plus isolés et organiser sa durabilité.

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée

Question 6 – Test de McNemar (1,5 pt)

Calcul posé – Test de McNemar avec correction de continuité

- Repas chaud : cases de changement b = 1 (oui → non) et c = 8 (non → oui) ; $\chi^2 = (|1 - 8| - 1)^2 / (1 + 8) = 6^2 / 9 = 36 / 9 =$ **4,00** > 3,84.
- Légumes : b = 1 et c = 6 ; $\chi^2 = (|1 - 6| - 1)^2 / (1 + 6) = 4^2 / 7 = 16 / 7 =$ **2,29** < 3,84.

Interprétation. Pour le repas chaud, le changement est **statistiquement significatif au risque de 5 %** : il est peu probable qu'une évolution aussi déséquilibrée (8 progressions pour 1 régression) soit due au hasard. Mais le résultat est à la limite (4,00 contre 3,84), et b + c = 9 est inférieur à 10 : le test est peu fiable avec si peu de changements. Un test exact (loi binomiale) donne une probabilité d'environ 0,04, ce qui confirme la conclusion avec la même prudence. Surtout, un test significatif ne prouve pas que le projet est la cause du changement : il dit seulement que le changement observé n'est probablement pas dû au hasard de l'échantillon.

Pour les légumes, le test n'est **pas significatif**, alors que la part passe de 27,8 % à 55,6 %. Le test de McNemar ne tient compte que des personnes qui ont **changé** (7 ici : 6 progressions et 1 régression) ; les 11 personnes stables n'apportent aucune information sur le changement. Avec 7 changements, l'écart entre 6 et 1 ne suffit pas à exclure le hasard. Cela ne veut pas dire que le projet n'a pas eu d'effet : l'effectif est trop faible pour conclure. On parle d'un résultat **encourageant mais non démontré**.

Question 7 – Groupe de comparaison (1,5 pt)

Calcul posé – Différence des évolutions et risque relatif

- Participants : 33,3 % → 72,2 %, soit **+ 38,9 points**. Comparaison : 7 / 20 = 35,0 % → 8 / 20 = 40,0 %, soit **+ 5,0 points**.
- Différence des évolutions : 38,9 − 5,0 = **33,9 points** en faveur de la résidence des Platanes.
- Risque relatif en fin de projet (repas chaud) : (13 / 18) / (8 / 20) = 0,722 / 0,400 = **1,81**.
- Erreur type de ln RR : √(1/13 − 1/18 + 1/8 − 1/20) = √(0,0769 − 0,0556 + 0,1250 − 0,0500) = √0,0964 = 0,310.
- IC à 95 % : exp(ln 1,81 ± 1,96 × 0,310) = exp(0,591 ± 0,608), soit **[0,98 ; 3,32]**.

Interprétation et comparabilité. La situation de départ était proche dans les deux résidences (33,3 % et 35,0 %), mais l'évolution a été beaucoup plus forte aux Platanes : la différence de 33,9 points est un argument en faveur d'un effet du projet. Le risque relatif en fin de projet est de 1,81, mais son intervalle de confiance contient 1 : avec ces effectifs, on ne peut pas exclure l'absence de différence. Les deux groupes ne sont pas parfaitement comparables : les résidents interrogés dans la résidence voisine sont des volontaires (biais de sélection) ; leurs cuisines ont été rénovées en 2026, ce qui facilite déjà la cuisine ; on ne sait rien de leur âge, de leur isolement ou de leur santé. La comparaison mesure deux groupes à deux dates, ce qui neutralise en partie l'effet de la saison (automne-hiver) et des événements communs.

Protocole plus solide pour la prochaine édition : définir à l'avance les indicateurs et la population (tous les résidents de 60 ans et plus des deux résidences, ou un tirage au sort de 30 résidents dans chacune) ; recueillir les mêmes caractéristiques (âge, isolement, lecture, diabète) pour vérifier la comparabilité ; faire passer le

questionnaire par une personne extérieure au projet ; ajouter une mesure à 6 mois pour le maintien ; si les deux résidences veulent le projet, le déployer **en décalé** (une résidence commence, l'autre six mois plus tard), ce qui crée un groupe de comparaison sans priver personne ; compléter par une mesure moins déclarative (fréquentation de la cuisine d'étage relevée sur un cahier, achats lors des sorties au marché).

Partie C – Veille

Question 8 – Veille sur l'évaluation (2 pts)

Élément	Organisation proposée
Sources	Répertoire des interventions efficaces ou prometteuses en prévention et promotion de la santé de Santé publique France ; portail de capitalisation des expériences en promotion de la santé (CAPS) ; ressources du réseau Promotion Santé (anciennes Ireps) ; rapports de la conférence des financeurs du département ; publications de l'Observatoire régional de la santé ; revues professionnelles (*La Santé en action*, *Santé publique*) ; bases bibliographiques (PubMed, Cairn) avec des mots-clés comme « older migrants », « nutrition », « community kitchen », « evaluation »
Outils	Alertes par courriel sur les bases et les sites ; abonnement aux lettres d'information ; logiciel de gestion de références ; fiche de lecture d'une page (référence datée, public, méthode, résultats, transférabilité)
Fréquence	Lecture des alertes chaque semaine ; synthèse mensuelle ; recherche approfondie avant chaque nouvelle édition du projet
Partage	Dossier partagé de la résidence ; point de veille de dix minutes à la réunion d'équipe mensuelle ; transmission des fiches à la diététicienne et à la médiatrice
Qualité	Distinguer données probantes, expériences capitalisées et opinions ; dater chaque source ; vérifier la transférabilité au contexte (public âgé, langue, habitat collectif) avec une grille comme ASTAIRE

Partie D – Communication et posture professionnelle

Question 9 – Plan de valorisation et éthique (1,5 pt)

Destinataire	Support	Message clé	Calendrier
Résidents (participants et non-participants)	Fête de restitution avec un repas préparé par les participants ; affiche imagée des résultats ; présentation orale en arabe, en tamazight et en français	« Vous êtes 13 sur 18 à cuisiner un repas chaud presque tous les soirs ; on continue, et la table est ouverte à tous »	Février 2028
Équipe de la résidence et bailleur	Rapport d'évaluation de 8 pages avec recommandations ; présentation au comité de pilotage	« Objectifs atteints ; priorité : toucher les plus isolés et garder la cuisine d'étage vivante »	Février 2028
Financeurs	Compte rendu financier Cerfa n° 15059 avec le reversement de 130,40 € ; bilan qualitatif avec les indicateurs	« Projet réalisé à 93,9 % du budget prévu, objectifs atteints, effets inattendus positifs »	Au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice
Professionnels	Poster pour une journée régionale de promotion de la santé ; fiche d'expérience pour le portail CAPS	« Cuisiner ensemble en résidence sociale : méthode, résultats et limites »	Printemps 2028
Élus et décideurs	Note de synthèse d'une page pour le contrat local de santé et le CCAS	« 294,55 € par participant pour rompre l'isolement et retrouver le repas du soir : une action à pérenniser »	Mars 2028

Précautions éthiques. Les paroles sont citées sans nom ni détail permettant d'identifier la personne (pas de « l'ancien maçon du 3e étage ») ; on demande l'accord des personnes pour citer leurs propos, en le leur expliquant dans leur langue. Les photos ne sont prises et diffusées qu'avec un accord écrit, expliqué oralement par la médiatrice, pour un usage précis (affiche interne, poster) ; une personne peut refuser sans conséquence. On n'associe jamais une photo à une information de santé (diabète). Les résultats sont présentés de manière collective et non stigmatisante (on évite « ces hommes ne savent pas cuisiner »).

Question 10 – Exposé et questions du jury (1,5 pt)

Trame de 10 minutes : contexte, demande et public (1 min) ; rappel du diagnostic et des objectifs (1 min 30) ; plan d'évaluation et outils adaptés (1 min 30) ; résultats de processus (1 min) ; résultats par objectif avec un graphique avant-après (2 min) ; équité, efficience et limites (1 min 30) ; valorisation et perspectives (1 min) ; conclusion (30 s).

Questions probables : Pourquoi n'avoir analysé que 18 questionnaires ? Que signifie le test de McNemar ? Le résultat significatif prouve-t-il l'efficacité ? Pourquoi la résidence voisine n'est-elle pas un bon groupe témoin ? Comment avez-vous adapté le questionnaire aux résidents qui ne lisent pas le français ? Que pensez-vous de la parole sur le sucre ? Pourquoi l'association doit-elle reverser 130,40 € ? Comment toucher les résidents les plus isolés ? Quel est l'impact du projet sur la perte d'autonomie ? Comment pérenniser sans la médiatrice ? Quels sont les effets inattendus ? Qu'avez-vous fait vous-même ?

Éléments de réponse pour quatre questions :

- **18 questionnaires** : on n'analyse que les réponses appariées, recueillies chez les mêmes personnes au début et à la fin ; comparer 20 réponses « avant » à 18 réponses « après » mélangerait deux groupes ; les 4 perdus de vue sont signalés comme une limite.
- **Test significatif et preuve** : le test dit que le changement n'est probablement pas dû au hasard ; il ne dit pas que le projet en est la cause (pas de groupe témoin vraiment comparable, données déclaratives) ; on parle de résultats encourageants.
- **Parole sur le sucre** : elle montre que les messages sur le diabète ont été vécus comme répétitifs ; pour la suite, on part des savoir-faire des résidents et l'on intègre les repères sans les répéter, en lien avec leur médecin.
- **Pérennisation** : les résidents qui cuisinent ensemble le mardi peuvent devenir des pairs relais ; la cuisine d'étage rénovée reste ; on demande un financement pluriannuel à la conférence des financeurs et l'on inscrit le repas partagé dans le projet social de la résidence.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages de résultat sur les 22 inscrits au lieu des 18 réponses appariées ; oublier les perdus de vue ; confondre taux de présence (174 / 220) et taux de fidélisation (17 / 22) ; présenter un test significatif comme une preuve d'efficacité, ou un test non significatif comme une preuve d'inefficacité ; oublier que le plafond de 52 % s'applique aux charges réalisées et ne pas calculer le reversement ; oublier les contributions en nature dans le coût total ; parler d'équité sans calculer la couverture des sous-groupes ; ignorer les paroles des résidents qui contredisent une partie du bilan ; valoriser uniquement auprès des financeurs en oubliant la restitution aux résidents.

Corrigé S2 – « Ma gamelle, c'est moi qui la fais » : un atelier culinaire pour des travailleurs d'un ESAT, et son évaluation

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat sait concevoir un atelier réellement accessible à des adultes avec une déficience intellectuelle : recette en images, une action par étape, gestes adaptés, place laissée à chacun, respect de l'adulte (on ne s'adresse pas à lui comme à un enfant). Il attend des calculs justes (bon de commande, coût, apports), une maîtrise de la sécurité sanitaire d'un déjeuner transporté jusqu'au lendemain et une gestion rigoureuse de l'allergie à l'arachide. La partie évaluation doit montrer des outils adaptés au public (observation, images), une lecture prudente des données de satisfaction et un plan de mesure des effets réalistes. Il pénalise un discours moralisateur sur les sodas, une recette illisible pour Madame C. et l'oubli de la chaîne du froid.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Besoins et objectifs (1,5 pt)

Calcul posé – Document 5 (32 déjeuners observés)

- Au moins un légume : 9 / 32 = **28,1 %** ; boisson sucrée : 14 / 32 = **43,8 %** ; seulement un produit de grignotage : 6 / 32 = **18,8 %** ; rien apporté : 3 / 32 = **9,4 %**.

Besoins. 1. Savoir composer et préparer un déjeuner complet transportable (moins d'un déjeuner sur trois contient un légume ; près d'un sur trois se limite à du grignotage ou à rien). 2. Remplacer une partie des boissons sucrées par de l'eau (présentes dans 43,8 % des déjeuners). 3. Gagner en autonomie et en sécurité pour préparer, étiqueter et conserver un repas, en particulier pour les quatre participants qui vivent seuls. Ces chiffres portent sur 8 personnes volontaires et 4 jours : ils décrivent ce groupe, sans être généralisables à l'ESAT.

Objectif général : contribuer à améliorer l'alimentation de midi des travailleurs de l'ESAT et leur autonomie pour préparer leurs repas.

Objectifs opérationnels (observés pendant l'atelier, grille de l'éducatrice) :

- Chaque participant assemble seul ou avec une aide légère une salade complète dans sa boîte, en suivant la recette en images.
- Au moins 6 participants sur 8 étiquettent leur boîte (prénom et date, par écrit ou avec une étiquette à coller) et la rangent au réfrigérateur.
- Chaque participant goûte l'eau aromatisée maison et cite ou montre sur une image une boisson à choisir à midi.

Question 2 – Bon de commande et budget (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 12 portions (11 au thon, 1 végétarienne)

Denrée	Net (g)	Brut (g)	Unité de commande	Coût (€)
Pâtes au blé complet	70 × 12 = 840	840	1 paquet de 1 kg	840 × 2,20 / 1 000 = 1,85
Thon égoutté	60 × 11 = 660	660	boîtes (poids égoutté)	660 × 16,00 / 1 000 = 10,56
Pois chiches égouttés	80 × 1 = 80	80	1 petite boîte	0,21
Haricots verts	60 × 12 = 720	720 / 0,90 = 800	800 g	3,36
Tomates cerises	720	720 / 0,95 = 757,9, soit 760	760 g	4,93
Maïs égoutté	240	240	1 boîte	0,96

Denrée	Net (g)	Brut (g)	Unité de commande	Coût (€)
Oignon rouge	120	120 / 0,90 = 133,3	1 gros oignon	0,37
Huile de colza	10,5 × 12 = 126	126	bouteille	0,40
Vinaigre	48	48	bouteille	0,07
Moutarde	24	24	pot	0,10
Yaourt nature	1 500	1 500	12 pots de 125 g	2,40
Flocons d'avoine	300	300	1 paquet de 500 g	0,72
Banane	240	240 / 0,65 = 369,2	3 bananes	0,74
Raisins secs	96	96	1 sachet	0,77
Clémentines	840	840 / 0,75 = 1 120	1,12 kg (12 fruits)	3,58
Herbes, sel, poivre	–	–	forfait	0,60

- Total pour 12 portions au thon : **32,37 €**, soit 32,37 / 12 = **2,70 €** par portion.
- Version végétarienne pour une portion : − 60 g de thon (60 × 16,00 / 1 000 = − 0,96 €) et + 80 g de pois chiches (80 × 2,60 / 1 000 = + 0,21 €), soit **− 0,75 €** (0,752 arrondi).
- Total réel : 32,37 − 0,752 = **31,62 €**, soit 31,62 / 12 = **2,63 €** par portion.
- Budget : 2,80 × 12 = **33,60 €** ; marge : 33,60 − 31,62 = **1,98 €** : le budget est respecté.
- Poste le plus coûteux : le thon, 10,56 / 31,62 × 100 = **33,4 %** du coût pour un seul ingrédient.

On peut réduire le coût en utilisant des haricots verts surgelés (moins chers hors saison) ou en remplaçant le thon par des œufs durs une fois sur deux ; la marge permet aussi d'acheter quelques citrons et de la menthe pour l'eau aromatisée.

Question 3 – Fiches techniques accessibles et adaptations (3 pts)

Salade de pâtes complètes (recette en images, une action par étape)

1. Je me lave les mains (photo d'un lavabo avec savon).
2. Je mets de l'eau dans la grande casserole. L'adulte allume la plaque.
3. Quand l'eau bout, je verse les pâtes (photo du paquet). Minuteur : 11 minutes.
4. Je coupe les haricots en deux (photo). Ils cuisent 8 minutes dans une autre casserole.
5. J'égoutte les pâtes et les haricots dans la passoire (geste fait avec l'éducatrice : eau bouillante).
6. Je les étale sur une grande plaque pour qu'ils refroidissent vite, puis la plaque va au réfrigérateur.
7. Je coupe les tomates cerises en deux sur la planche (couteau à bout rond).
8. J'ouvre et j'égoutte le thon et le maïs (ouvre-boîte à levier).
9. Je mets dans ma boîte : 1 verre doseur bleu de pâtes, 1 verre doseur vert de haricots, 6 tomates, 1 cuillère de maïs, 2 cuillères de thon.
10. Je ferme ma boîte, je colle mon étiquette (prénom, date), je range la boîte au réfrigérateur.

Vinaigrette (préparée par un binôme dans un pot à confiture fermé) : 1 cuillère à café de moutarde, 2 cuillères à soupe de vinaigre, 6 cuillères à soupe d'huile de colza ; fermer le couvercle et secouer ; la vinaigrette est mise dans un petit pot à part, à verser au moment de manger, pour que la salade reste ferme. Point critique : moutarde (allergène à signaler).

Barres maison (pour 12) : écraser 3 bananes à la fourchette dans un saladier ; ajouter 300 g de flocons d'avoine, 96 g de raisins secs et 30 g d'huile de colza ; mélanger ; étaler dans un moule chemisé de papier cuisson, sur 1,5 cm ; cuire 20 minutes à 180 °C ; laisser refroidir, puis découper en 12 barres. Points critiques : vérifier sur les paquets de flocons et de raisins l'absence d'arachide et de mention « peut contenir des traces d'arachide » ; sortir le moule du four (tâche de l'adulte, gants).

Personne	Adaptation	Justification
Monsieur B.	Proposer une eau aromatisée maison (citron, menthe) et une gourde à son nom ; parler de goût et de plaisir, sans juger les sodas ; fixer avec lui un petit objectif choisi par lui (par exemple, de l'eau au déjeuner, le soda gardé pour le week-end)	Il boit environ un litre de soda par jour ; un changement imposé ou culpabilisant a peu de chances de tenir
Madame C.	Recette entièrement en images, avec des couleurs pour les verres doseurs ; étiquette prénom imprimée à coller ; démonstration de chaque geste ; pas de tâche près des plaques sans accompagnement	Elle ne lit pas mais reconnaît les images ; épilepsie stabilisée : on évite le travail seule près d'une source de chaleur et l'on connaît la conduite à tenir en cas de crise
Madame E.	Vérification de toutes les étiquettes avant l'atelier ; aucun produit contenant de l'arachide ou portant la mention « peut contenir » dans la salle ; plan de travail et ustensiles lavés avant ; stylo d'adrénaline repéré et éducatrice informée du protocole	Allergie à l'arachide : risque de réaction grave
Monsieur F.	Version végétarienne avec 80 g de pois chiches ; préparée en premier, sur une planche propre, avec une cuillère dédiée	Respect de son choix ; éviter le contact avec le thon
Madame G.	Planche antidérapante à picots pour tenir les tomates, ouvre-boîte à levier, saladier sur un tapis antidérapant ; tâches à une main (assembler, mélanger, coller l'étiquette)	Faiblesse de la main gauche : on l'aide à faire, on ne fait pas à sa place
Monsieur H.	Même déjeuner, avec des pâtes complètes et des légumes qui ralentissent l'absorption des glucides ; une seule barre ; pas de jus de fruits ; eau comme boisson	Diabète de type 2 : glucides répartis dans le repas, féculents complets, fibres

Question 4 – Apports nutritionnels (2 pts)

Calcul posé – Apports d'une portion du déjeuner (version au thon), Ciqual 2025

- **Salade et vinaigrette** : 471,5 kcal ; protéines 27,03 g ; glucides 57,52 g ; sucres 7,13 g ; lipides 12,64 g ; fibres 7,48 g ; sel 0,71 g ; calcium 59,7 mg ; fer 3,69 mg ; vitamine C 21,3 mg. Exemples : pâtes 70 × 353 / 100 = 247,1 kcal ; thon 60 × 26,8 / 100 = 16,08 g de protéines ; huile 8 × 900 / 100 = 72 kcal.
- **Yaourt** (125 g) : 62,6 kcal ; protéines 4,79 g ; calcium 125 × 137 / 100 = 171,3 mg.
- **Barre** (25 g de flocons, 20 g de banane, 8 g de raisins, 2,5 g d'huile) : 158,0 kcal ; glucides 24,22 g ; sucres 9,00 g ; lipides 4,53 g ; fibres 3,68 g.
- **Clémentine** (70 g) : 31,9 kcal ; vitamine C 70 × 49,2 / 100 = 34,4 mg.
- **Total** : **724,0 kcal** ; protéines **35,48 g** ; glucides **93,49 g** dont sucres **27,15 g** ; lipides **19,27 g** ; fibres **12,35 g** ; sel **0,84 g** ; calcium **265,4 mg** ; fer **4,88 mg** ; vitamine C **57,1 mg**.
- Répartition de l'énergie : protéines 35,48 × 4 / 724,0 = **19,6 %** ; lipides 19,27 × 9 / 724,0 = **23,9 %** ; glucides 93,49 × 4 / 724,0 = **51,6 %**. Le total (95,1 %) est inférieur à 100 % car les fibres apportent aussi de l'énergie (12,35 × 2 = 24,7 kcal, soit 3,4 %), et à cause des arrondis.
- Version végétarienne (− thon, + 80 g de pois chiches) : **735,9 kcal** ; protéines **24,80 g** ; glucides 105,49 g ; lipides 19,05 g ; fibres **16,71 g** ; sel 0,83 g ; calcium 294,6 mg ; fer 5,34 mg.

Calcul posé – Barre maison et barre du commerce

- Barre maison (55,5 g de mélange cru) : 158,0 kcal ; sucres 9,00 g (aucun sucre ajouté : ils viennent de la banane et des raisins) ; fibres 3,68 g ; sel 0 g. Pour 100 g de mélange : 158,0 / 55,5 × 100 = **284,7 kcal** ; sucres 9,00 / 55,5 × 100 = **16,2 g** ; fibres **6,6 g**.

- Barre céréalière aux fruits du commerce (25 g) : 25 × 379 / 100 = **94,8 kcal** ; sucres 25 × 29,6 / 100 = **7,40 g** ; fibres **0,95 g** ; sel 0,16 g. Pour 100 g : 379 kcal ; sucres **29,6 g** ; fibres **3,8 g**.

Commentaire. Le déjeuner apporte environ 724 kcal, ce qui correspond à un repas principal pour un adulte actif ; les protéines sont bien couvertes (35,5 g). Les fibres (12,35 g, soit 41,2 % des 30 g quotidiens) sont élevées pour un seul repas, grâce aux pâtes complètes, aux légumes, à l'avoine et au fruit ; la version végétarienne monte à 16,71 g (55,7 %). Le repas contient au moins deux portions de fruits et légumes (haricots, tomates, clémentine) et un produit laitier ; le sel reste modéré (0,84 g). Le calcium (265,4 mg, 27,9 % de 950 mg) vient surtout du yaourt. Pour Monsieur B., l'apport énergétique est raisonnable à condition que la boisson soit de l'eau : un litre de cola sucré ajouterait environ 1 000 × 40,1 / 100 = 401 kcal et 100 g de sucres (Ciqual 2025, cola sucré, code 18018 : 40,1 kcal et 10 g de sucres pour 100 g ; on compte 1 L ≈ 1 000 g). La comparaison des barres montre un piège de lecture : **par barre**, la barre maison contient plus de sucres (9,0 g contre 7,4 g) parce qu'elle est plus grosse ; **pour 100 g**, elle en contient presque deux fois moins (16,2 g contre 29,6 g), sans sucre ajouté, avec plus de fibres. On compare toujours pour 100 g, puis on regarde la portion réellement mangée.

Question 5 – Préparer, refroidir, transporter, conserver (1,5 pt)

- Les pâtes et les haricots cuits sont **refroidis rapidement** : étalés sur une plaque, puis placés au réfrigérateur, pour passer sous + 10 °C en moins de 2 heures ; on n'assemble la salade qu'avec des ingrédients froids.
- La salade est mise en boîte hermétique **propre**, étiquetée (prénom, date de préparation), rangée au réfrigérateur de l'ESAT (0 à + 4 °C) jusqu'au départ.
- Le thon et le maïs non utilisés ne sont pas conservés dans leur boîte ouverte : on les transvase dans un récipient fermé, au froid, à consommer dans les 24 heures.
- Transport : sac isotherme avec pain de glace ; dès l'arrivée au domicile ou au foyer, la boîte va au réfrigérateur ; le lendemain matin, retour dans le sac isotherme avec le pain de glace, puis au réfrigérateur de l'ESAT jusqu'à midi.
- La vinaigrette voyage à part ; le yaourt reste au froid ; la barre et la clémentine se conservent à température ambiante.
- Le déjeuner est consommé **le lendemain midi au plus tard** ; ce qui n'a pas été mangé est jeté. Un participant qui n'a pas de réfrigérateur fonctionnel laisse sa boîte à l'ESAT pour la nuit.
- La boîte est lavée chaque soir à l'eau chaude savonneuse et séchée.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté des 3 heures (2 pts)

Horaire	Candidat	Participants
12 h 30 – 13 h 30	Mise en place : vérification des étiquettes (arachide), postes de travail, recettes en images affichées, verres doseurs de couleur, étiquettes imprimées ; préparation de l'eau aromatisée ; cuisson d'une portion de démonstration	–
13 h 30 – 13 h 45	Accueil, présentation de chacun, règles de l'atelier (mains, couteaux, plaques), présentation du déjeuner en photos	Lavage des mains, port du tablier
13 h 45 – 14 h 15	Démonstration puis supervision de la cuisson ; lancement des barres par un binôme	Cuisson des pâtes et des haricots (en binôme avec l'éducatrice) ; deux participants préparent les barres, Madame G. mélange
14 h 15 – 14 h 30	Refroidissement sur plaques ; préparation de la vinaigrette	Lavage et découpe des tomates (couteau à bout rond) ; égouttage du thon, du maïs, des pois chiches
14 h 30 – 14 h 45	Pause et dégustation de l'eau aromatisée ; échange sur les boissons de midi avec des images	Pause, dégustation

Horaire	Candidat	Participants
14 h 45 – 15 h 10	Accompagnement de l'assemblage ; découpe des barres refroidies	Assemblage dans la boîte avec les verres doseurs ; étiquetage ; rangement au réfrigérateur ; dégustation d'un morceau de barre
15 h 10 – 15 h 30	Évaluation (grille, échelle à trois visages) ; remise de la recette en images	Rangement collectif, choix d'un visage, chacun dit ou montre ce qu'il refera
15 h 30 – 16 h	Remise en état, nettoyage et désinfection, fiche de bilan, inventaire	–

Question 7 – Méthodes, outils, boissons, allergie (1,5 pt)

- **Démonstration courte puis pratique** : chaque geste est montré une fois, puis fait par les participants ; on adapte le rythme, on répète sans impatience.
- **Binômes** : un participant à l'aise avec un participant qui a besoin d'aide ; l'éducatrice et le candidat circulent.
- **Outils** : recette en photos sur fond contrasté ; verres doseurs de couleur (bleu pour les pâtes, vert pour les légumes) qui remplacent la pesée ; étiquettes prénom imprimées ; minuteur visuel.
- **Faire dire et faire montrer** : « Montre-moi ce que tu mets dans ta boîte demain », plutôt qu'une question fermée.
- **Boissons sucrées** : on ne dit pas « le soda, c'est mauvais ». On fait goûter deux ou trois eaux aromatisées et l'on vote pour la préférée ; on montre en images la quantité de sucre d'une canette par des morceaux de sucre, sans insister ; on propose de choisir soi-même un petit changement. On parle à des adultes : on respecte leurs choix.
- **Allergie** : liste des ingrédients vérifiée avant l'atelier ; affichage des allergènes de chaque préparation (gluten des pâtes et de l'avoine, poisson, lait, moutarde) ; aucun aliment apporté de l'extérieur ; conduite à tenir en cas de réaction connue de l'équipe (stylo d'adrénaline, appel du 15).

Question 8 – Hygiène, sécurité, éco-gestes (1,5 pt)

Hygiène : lavage des mains à l'arrivée, après être allé aux toilettes et après avoir touché le thon ; cheveux attachés, tablier ; plans de travail nettoyés et désinfectés avant et après ; une planche et un couteau pour les légumes, d'autres pour le thon ; contrôle de la température du réfrigérateur ; refroidissement rapide et chaîne du froid jusqu'au lendemain. Sécurité : seuls les adultes égouttent l'eau bouillante et sortent les plats du four ; couteaux à bout rond ; câbles et sols dégagés ; trousse de secours et numéros d'urgence affichés ; conduite à tenir en cas de crise d'épilepsie connue de l'éducatrice. Éco-gestes : boîtes et gourdes réutilisables au lieu d'emballages jetables ; eau du robinet aromatisée au lieu de bouteilles ; épluchures et restes de cuisson compostés si l'ESAT a un composteur (atelier espaces verts) ; cuisson à couvert pour économiser l'énergie.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (2,5 pts)

Critères d'évaluation de la réalisation : pâtes cuites al dente et refroidies rapidement ; haricots encore croquants et bien verts ; tomates coupées régulièrement ; vinaigrette émulsionnée, conditionnée à part ; barres cuites, fermes, découpées régulièrement ; version végétarienne réalisée sans contact avec le thon ; deux déjeuners complets en boîtes hermétiques, étiquetés (contenu, date, allergènes), rangés au froid ; poste propre et rangé ; gestes d'hygiène constants.

Question 10 – Évaluation de l'atelier et plan à un mois (2,5 pts)

Calcul posé – Grille d'observation (8 participants)

Compétence	Fait seul	Avec aide	Pas fait
Se laver les mains au bon moment	6 / 8 = 75,0 %	25,0 %	0 %
Égoutter le thon ou les pois chiches	7 / 8 = 87,5 %	12,5 %	0 %
Peser ou mesurer avec un verre doseur	4 / 8 = 50,0 %	37,5 %	12,5 %

Compétence	Fait seul	Avec aide	Pas fait
Assembler sa salade dans la boîte	8 / 8 = 100 %	0 %	0 %
Écrire ou coller l'étiquette	3 / 8 = 37,5 %	50,0 %	12,5 %
Ranger sa boîte au réfrigérateur	8 / 8 = 100 %	0 %	0 %

- Satisfaction : 7 / 8 = **87,5 %** de visages souriants ; 1 neutre (12,5 %).
- Objectif opérationnel 2 (au moins 6 sur 8 étiquettent et rangent) : étiquetage seul ou avec aide 3 + 4 = **7 sur 8** ; rangement 8 sur 8 : objectif atteint si l'on accepte l'étiquetage avec aide.

Lecture. Assembler et ranger sa boîte sont acquis par tous ; égoutter est presque acquis. Deux compétences sont à retravailler : **mesurer** (la moitié a besoin d'aide ou ne le fait pas) et **étiqueter** (5 sur 8 ont besoin d'aide ou ne le font pas), deux gestes qui demandent de lire, d'écrire ou de compter. Il faut donc simplifier encore (étiquettes pré-imprimées avec le prénom, tampon dateur, verres doseurs pleins « à ras ») et refaire ces gestes lors d'un deuxième atelier. Le lavage des mains « au bon moment » reste à consolider pour 2 participants. **Limites de la satisfaction** : une échelle à trois visages est adaptée au public, mais elle est peu nuancée ; les adultes avec une déficience intellectuelle peuvent avoir tendance à répondre ce qu'ils pensent que l'animateur attend (acquiescement) ; la réponse est donnée devant le groupe ; la satisfaction ne dit rien de ce qui changera dans les déjeuners. On complète par une question ouverte (« qu'est-ce que tu as aimé ? ») et par l'observation à distance.

Plan d'évaluation à un mois.

Élément	Proposition
Indicateurs	Part des déjeuners contenant au moins un légume (état initial 28,1 %, cible 50 %) ; part des déjeuners avec une boisson sucrée (état initial 43,8 %, cible 30 %) ; nombre de jours sans déjeuner (3 sur 32 au départ) ; nombre de participants ayant refait la salade ou une variante chez eux
Outils	Même observation que le document 5, par le même moniteur, pendant 4 jours, avec la même grille (comparaison avant-après sur les mêmes 8 personnes) ; court entretien individuel avec des images (« montre ce que tu as préparé ») ; échange avec le service d'accompagnement à la vie sociale pour les quatre personnes qui vivent seules
Consentement	Expliqué avec des mots simples et un document en FALC ; accord de la personne elle-même pour l'observation de son déjeuner, avec la possibilité de refuser sans conséquence ; information du représentant légal si une mesure de protection le prévoit ; résultats présentés sans nom
Analyse	Comparaison des pourcentages avant et après avec les effectifs (sur 32 déjeuners) ; tableau de transition par personne (« au moins un légume dans la moitié de ses déjeuners » : oui ou non, avant et après) ; prudence : petit groupe, observation qui peut modifier le comportement (effet Hawthorne), saison différente
Utilisation	Restitution aux participants avec des photos de leurs déjeuners (avec accord) ; ajustement du deuxième atelier ; décision de proposer l'atelier à d'autres travailleurs

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Oublier la perte de la banane et des clémentines dans le bon de commande ; calculer le coût avec 12 portions au thon sans corriger la portion végétarienne ; comparer les barres seulement par portion et conclure que la barre maison est plus sucrée ; oublier le refroidissement rapide des pâtes et la chaîne du froid jusqu'au lendemain ; laisser des produits « peut contenir des traces d'arachide » dans la salle ; proposer une recette écrite à Madame C. ; faire à la place de Madame G. au lieu d'adapter le matériel ; tenir un discours culpabilisant sur les sodas ou infantilisant ; présenter 87,5 % de satisfaction comme une preuve d'efficacité ; observer les déjeuners sans le consentement des personnes.

Corrigé S3 – « Le bip sonne toujours quand on passe à table » : évaluer un projet dans un centre de secours, le faire adopter, et animer un atelier « repas de garde »

> **que le jury attend**
>
> Au temps 1, le jury attend une évaluation finale complète et nuancée : des indicateurs calculés avec les bons dénominateurs, un indicateur indirect (les tickets d'achat) exploité avec ses limites, un test appliqué correctement, une analyse qualitative qui éclaire les chiffres, un jugement selon des critères explicites et une réflexion sur la transférabilité vers d'autres centres. Au temps 2, il attend un repas adapté à des professionnels très actifs, des calculs justes et surtout une organisation sûre face à l'imprévu (départ en intervention), sans compromis sur l'hygiène. Il valorise la capacité à associer les « anciens » au lieu de les opposer aux référents. Il pénalise un taux de réponse confondu avec le nombre de réponses appariées, une part des fruits et légumes calculée sur un total faux, et un plat de volaille partiellement cuit conservé après deux heures à température ambiante.

Temps 1 – L'évaluation finale et la valorisation du projet

Question 1 – Taux de réponse et objectifs opérationnels (1 pt)

> **Calcul posé – Document 3**
>
> - Taux de réponse : septembre 58 / 64 = **90,6 %** ; février 49 / 64 = **76,6 %** ; réponses appariées 44 / 64 = **68,8 %** des agents.
> - Utilisation du carnet : 41 / 56 × 100 = **73,2 %** des gardes (cible 80 %).

Les quatre référents ont été formés et le carnet a été diffusé : ces objectifs sont atteints. L'utilisation du carnet (73,2 %) reste en dessous de la cible de 80 % ; l'écart est modéré (il aurait fallu 45 gardes sur 56, soit 4 de plus). Les achats groupés hebdomadaires ne sont pas documentés : il faut le relever comme une lacune du suivi. Le taux de réponse baisse entre septembre et février (perte de 9 répondants) : on analyse les 44 réponses appariées et l'on signale que les non-répondants de février sont peut-être les agents les moins impliqués.

Question 2 – Les achats de la popote et l'objectif spécifique 2 (2,5 pts)

> **Calcul posé – Totaux, coût par repas et parts**
>
> - Total avant : 412 + 186 + 0 + 798 + 214 + 236 + 318 + 402 = **2 566 €** ; total en fin de projet : 690 + 240 + 96 + 610 + 236 + 128 + 196 + 188 = **2 384 €** ; évolution : − 182 €, soit − 182 / 2 566 × 100 = **− 7,1 %**.
> - Coût par repas : 2 566 / 1 344 = **1,91 €** avant ; 2 384 / 1 344 = **1,77 €** en fin de projet (− 0,14 €).

Catégorie	Part avant	Part en fin de projet	Évolution (€)	Évolution (%)
Fruits et légumes	16,1 %	28,9 %	+ 278	+ 67,5 %
Féculents	7,2 %	10,1 %	+ 54	+ 29,0 %
Légumes secs	0 %	4,0 %	+ 96	nouveau poste
Viandes et charcuteries	31,1 %	25,6 %	− 188	− 23,6 %
Produits laitiers	8,3 %	9,9 %	+ 22	+ 10,3 %
Boissons sucrées	9,2 %	5,4 %	− 108	− 45,8 %
Biscuits et confiseries	12,4 %	8,2 %	− 122	− 38,4 %
Plats préparés	15,7 %	7,9 %	− 214	− 53,2 %

> - Exemple de calcul : fruits et légumes avant 412 / 2 566 × 100 = 16,1 % ; après 690 / 2 384 × 100 = 28,9 %.
> - Augmentation relative de la part des fruits et légumes : (28,94 − 16,06) / 16,06 × 100 = **+ 80,3 %** (cible : au

moins + 50 %).

Jugement. L'objectif spécifique 2 est **atteint sur ses deux volets** : la part des fruits et légumes dans les achats augmente de 80,3 % (de 16,1 % à 28,9 %), et le coût par repas baisse de 1,91 € à 1,77 €. Le panier se transforme dans le sens des repères : plus de fruits, de légumes, de féculents et de légumes secs ; moins de plats préparés, de biscuits, de boissons sucrées et de viandes. La baisse du coût s'explique par le remplacement de produits transformés chers par des produits bruts cuisinés.

Un indicateur indirect. Les tickets d'achat ne mesurent pas ce que chaque agent mange, mais ce que la popote achète : c'est un indicateur **indirect** de la consommation. Avantages : il est objectif (non déclaratif), peu coûteux (les tickets existent déjà), il porte sur tous les repas et il est facile à suivre dans le temps. Limites : il ne dit rien des quantités consommées ni du gaspillage ; il ignore ce que les agents apportent de chez eux ou achètent hors de la popote ; une partie de l'évolution peut venir de la saison (plus de légumes de soupe en hiver) ou des prix ; on compare des euros et non des quantités. On le complète par le questionnaire et par un relevé ponctuel des restes.

Question 3 – Collation de nuit et objectif spécifique 1 (1,5 pt)

Calcul posé – Tableau de transition (44 agents)

- Septembre : 29 / 44 = **65,9 %** ; février : 18 / 44 = **40,9 %** ; évolution : − 25,0 points.
- Réduction relative : (65,9 − 40,9) / 65,9 × 100 = **37,9 %** (cible : au moins un tiers, soit 33,3 %).
- Parmi les 29 agents concernés en septembre, 14 ont arrêté : 14 / 29 = **48,3 %** ; parmi les 15 agents non concernés, 3 ont commencé : 3 / 15 = **20,0 %**.

L'objectif spécifique 1 est atteint : la part des agents qui prennent une collation sucrée ou grasse la nuit diminue de 37,9 %. Près de la moitié des agents concernés ont changé, ce que confirme le verbatim sur la « boîte de nuit préparée à l'avance ». Trois agents ont pris l'habitude inverse : il faut comprendre pourquoi (changement de rythme de garde, stress, boîte non préparée), sans les montrer du doigt. La note de satisfaction progresse de 5,8 à 7,1 : le changement ne s'est pas fait au détriment du plaisir, ce qui est essentiel pour qu'il dure.

Question 4 – Analyse des groupes de discussion (1,5 pt)

Calcul posé – Part des thèmes (46 mentions)

- Total des mentions : 11 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 = **46**.
- Départs en intervention 11 / 46 = **23,9 %** ; convivialité **19,6 %** ; goût **17,4 %** ; sommeil et collation de nuit **15,2 %** ; coût **13,0 %** ; « un pompier, ça mange de la viande » **10,9 %**.

Le nombre de mentions indique l'importance d'un thème dans la discussion, pas la proportion d'agents qui pensent la même chose (un agent peut parler plusieurs fois). Trois enseignements : 1. **Les départs en intervention** sont la première difficulté : il faut adapter les menus (plats mijotés qui supportent le maintien au chaud ou le refroidissement et le réchauffage, préparation en deux temps) et former les référents à une procédure sûre ; c'est l'objet de l'atelier du temps 2. 2. **La convivialité et le goût** sont des leviers : le repas de garde est un moment d'équipe, le projet doit le renforcer et non le transformer en « régime » ; les plats nouveaux sont acceptés quand ils sont bons. 3. **La culture professionnelle** (« un pompier, ça mange de la viande ») concerne une minorité mais pèse sur l'ambiance : on associe les anciens à l'élaboration des menus, on garde de la viande dans les menus en variant les sources de protéines, sans opposer les générations.

Question 5 – Jugement évaluatif et proportionnalité (2,5 pts)

Critère	Jugement argumenté
Pertinence	Forte : le projet répond aux constats de la médecine professionnelle (prise de poids, collations nocturnes) et aux contraintes de la garde de 24 heures ; il s'appuie sur une pratique existante (la popote).

Critère	Jugement argumenté
Cohérence	Bonne cohérence interne (référents, carnet, achats groupés, collation de nuit) ; cohérence externe avec les missions du service de santé et de secours médical et de la médecine professionnelle.
Efficacité	Les deux objectifs spécifiques sont atteints (– 37,9 % de collations nocturnes sucrées ou grasses ; + 80,3 % pour la part des fruits et légumes) ; un objectif opérationnel est partiellement atteint (carnet utilisé dans 73,2 % des gardes).
Efficience	Coût du projet 9 800 € pour 64 agents, soit 9 800 / 64 = **153,13 €** par agent ; le coût par repas de la popote a baissé de 0,14 €, et les dépenses de la popote de 2 566 − 2 384 = **182 €** sur 8 semaines, à nombre de repas égal : une économie pour les agents.
Impact	Effets inattendus : diffusion spontanée dans 4 centres, meilleure satisfaction des repas ; l'effet sur le poids et la santé n'est pas mesurable en six mois et ne doit pas être affirmé.
Viabilité	Bonne si les référents restent en poste et sont remplacés en cas de mutation, si le carnet est actualisé et si la procédure « départ en intervention » rend les menus réalistes ; fragile si tout repose sur 4 personnes.

Proportionnalité de l'évaluation. L'évaluation a coûté 1 400 / 9 800 × 100 = **14,3 %** du budget. Il n'existe pas de règle fixe : on juge la proportionnalité selon l'usage des résultats. Ici, la dépense se justifie, car le projet doit être présenté pour une diffusion à onze centres : la direction a besoin de résultats solides pour décider. Elle a été économe dans ses méthodes : les tickets d'achat existaient déjà, le questionnaire était court, les groupes de discussion ont réuni 14 agents. Pour la diffusion dans les autres centres, une évaluation allégée suffira (tickets d'achat et utilisation du carnet), avec une évaluation approfondie dans un ou deux centres seulement.

Partie B – Recherche appliquée

Question 6 – Test de McNemar et biais (1,5 pt)

Calcul posé – Test de McNemar

- Cases de changement : b = 3 (non → oui) et c = 14 (oui → non) ; b + c = 17.
- $\chi^2 = (|3 - 14| - 1)^2 / (3 + 14) = 10^2 / 17 = 100 / 17 =$ **5,88** > 3,84.

Le changement est **significatif au risque de 5 %** : il est peu probable qu'un déséquilibre de 14 arrêts pour 3 débuts soit dû au hasard. Avec 17 changements, le test est applicable. Cela ne démontre pas que le projet en est la seule cause. Trois biais possibles : **désirabilité sociale** (les agents savent ce que l'on attend ; on limite ce biais avec un questionnaire anonyme, rempli seul, et en recoupant avec les tickets d'achat) ; **biais d'attrition** (les 14 agents qui n'ont pas répondu en février sont peut-être ceux qui ont le moins changé ; on décrit leurs caractéristiques de septembre et l'on relance) ; **absence de groupe de comparaison** (une campagne nationale ou un changement de rythme des gardes a pu jouer ; on peut utiliser comme comparaison un centre qui commence le projet plus tard). On peut ajouter la **saisonnalité** : les deux mesures ne sont pas faites à la même saison.

Question 7 – Transférabilité et adoption (1,5 pt)

L'**adoption** est encourageante : 4 centres sur 11 ont demandé le carnet (36,4 %), 2 ont désigné un référent (18,2 %). Dans RE-AIM, l'adoption mesure la part des structures qui s'approprient l'action ; elle est ici spontanée, donc portée par un réel intérêt.

Dimension (ASTAIRE)	Analyse pour les autres centres
Population	Sapeurs-pompiers en garde de 24 heures : même profil dans le groupement ; vérifier la part de volontaires, qui ne vivent pas la même organisation des repas
Environnement	Existence d'une cuisine équipée et d'une popote dans chaque centre ; matériel de refroidissement rapide disponible ou non ; soutien du chef de centre

Dimension (ASTAIRE)	Analyse pour les autres centres
Mise en œuvre	Formation des référents par ceux du centre de Valcourt ; carnet de menus à adapter aux équipements et aux habitudes locales
Accompagnement du transfert	Appui de la diététicienne et du service de santé et de secours médical ; temps de formation reconnu ; échanges entre référents

Fonctions clés à conserver : des référents formés et reconnus dans chaque centre ; un carnet de menus de garde testé ; la collation de nuit préparée à l'avance ; la procédure sûre en cas de départ ; l'implication de l'équipe dans le choix des menus (participation). **Éléments adaptables** : recettes, fréquence des achats groupés, fournisseurs, outils de suivi. **Conditions de réussite** : soutien du chef de centre et de l'amicale, remplacement des référents mutés, une évaluation simple et commune (tickets d'achat, utilisation du carnet).

Partie C – Veille

Question 8 – Veille (2 pts)

Élément	Organisation proposée
Sources	Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), avis et expertises sur le travail de nuit ; Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ; Santé publique France ; publications des services de santé et de secours médical et de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ; bases bibliographiques (PubMed : « firefighters », « shift work », « diet ») ; portail CAPS pour les expériences de prévention
Outils	Alertes par mots-clés ; abonnement aux lettres d'information ; tableau de veille partagé (référence datée, résumé, utilité pour le projet)
Fréquence	Alertes lues chaque semaine ; synthèse mensuelle ; mise à jour du carnet de menus chaque année
Diffusion	Fiche d'une page envoyée aux référents ; point de veille lors de la réunion trimestrielle des référents ; espace partagé du groupement

Partie D – Communication et posture

Question 9 – Présentation au comité de direction et capitalisation (1,5 pt)

Plan de 10 minutes : le problème (1 min) ; le projet en trois actions (2 min) ; les résultats avec trois chiffres clés (3 min) ; les limites (1 min) ; la proposition de diffusion (2 min) ; la décision attendue (1 min). **Chiffres clés** : collations nocturnes sucrées ou grasses de 65,9 % à 40,9 % des agents ; part des fruits et légumes dans les achats de 16,1 % à 28,9 % ; coût par repas de 1,91 € à 1,77 €. **Graphique** : barres groupées « avant / fin de projet » de la part de chaque catégorie dans les achats. **Recommandation** : diffuser le projet aux centres volontaires, avec deux référents par centre, un carnet adapté localement et une évaluation simplifiée commune.

Fiche de capitalisation (une page) : titre ; contexte et public ; objectifs ; actions ; ressources et coût ; résultats chiffrés ; ce qui a marché (référents, collation de nuit, plats bons et économiques) ; difficultés (départs en intervention, résistances) ; conditions de transfert ; contact.

« Un pompier, ça mange de la viande ». On ne répond pas par un discours nutritionnel en public. On reconnaît la valeur du repas de garde et de son histoire ; on rappelle que le projet ne supprime pas la viande mais varie les protéines et réduit les plats préparés ; on propose aux anciens de rédiger ou de tester des menus (par exemple, un plat mijoté traditionnel revisité) ; on s'appuie sur les chiffres de la popote (coût en baisse) et sur les agents qui ont apprécié les nouveaux plats. L'objectif est que chacun se sente respecté et associé.

Question 10 – Exposé au jury (1,5 pt)

Trame : contexte et demande (1 min) ; le projet et ses objectifs (1 min 30) ; méthode d'évaluation, dont l'indicateur indirect (2 min) ; résultats et test (2 min) ; analyse qualitative (1 min) ; jugement et limites (1 min 30) ; transfert et valorisation (1 min).

Questions probables et éléments de réponse :

- *Pourquoi utiliser les tickets d'achat ?* Indicateur objectif et peu coûteux, qui complète un questionnaire déclaratif ; limites : achats et non consommation, saison.
- *Le test prouve-t-il l'efficacité ?* Non : il montre que le changement n'est probablement pas dû au hasard ; l'attribution au projet reste plausible mais non démontrée.
- *Que faites-vous des 3 agents qui ont commencé une collation de nuit ?* Comprendre sans stigmatiser, vérifier que la boîte de nuit est réaliste pour toutes les gardes.
- *Pourquoi 14,3 % du budget pour l'évaluation ?* Pour fonder une décision de diffusion à onze centres ; méthodes économes ; évaluation allégée ensuite.
- *Quelle est votre contribution personnelle ?* Analyse des tickets et des questionnaires, codage des groupes de discussion, préparation de la présentation et de l'atelier.

Temps 2 – L'atelier « repas de garde qui supporte le bip »

Question 11 – Objectifs (1,5 pt)

Objectif général : contribuer à une alimentation favorable à la santé des sapeurs-pompiers pendant les gardes, en préservant la convivialité de la popote. **Objectifs opérationnels** : chaque agent participe à au moins une étape de la préparation et cite les deux options sûres en cas de départ (maintien au-dessus de 63 °C ou refroidissement rapide puis réchauffage) ; les deux référents mesurent la température à cœur du poulet et du plat réchauffé avec le thermomètre à sonde ; à la dégustation, au moins 8 agents sur 10 donnent une note d'au moins 7 sur 10 au plat.

Question 12 – Bon de commande et budget (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 12 portions

Denrée	Net	Brut	Coût (€)
Filets de poulet	120 × 12 = 1 440 g	1 440 g	1,440 × 10,90 = 15,70
Poivrons rouges	960 g	960 / 0,80 = 1 200 g	1,200 × 3,50 = 4,20
Oignons	360 g	360 / 0,90 = 400 g	0,72
Tomates pelées au jus	960 g	960 g (une boîte de 1 kg)	1,82
Ail	24 g	24 / 0,85 = 28,2 g	0,23
Huile d'olive	72 g	72 g	0,68
Riz complet	960 g	960 g (un paquet de 1 kg)	2,50
Chou rouge	960 g	960 / 0,80 = 1 200 g	1,92
Huile de colza	72 g	72 g	0,23
Vinaigre	36 g	36 g	0,05
Fromage blanc	1 200 g	1 200 g	3,12
Framboises surgelées	600 g	600 g	4,74
Paprika, sel, poivre, herbes	–	–	0,80

- Total : **36,71 €**, soit 36,71 / 12 = **3,06 €** par portion ; budget : 3,50 × 12 = 42,00 € ; marge : 42,00 − 36,71 = **5,29 €**.
- Poste le plus coûteux : le poulet, 15,70 / 36,71 × 100 = **42,8 %** du coût.

Question 13 – Fiches techniques et adaptations (3 pts)

Salade de chou rouge : laver le chou, retirer les premières feuilles et le trognon, émincer finement ; vinaigrette (huile de colza, vinaigre, moutarde facultative, poivre) ; assaisonner 30 minutes à l'avance pour attendrir le chou ; conserver au froid. *Émincé de poulet basquaise* : préparer d'abord la sauce (oignons et poivrons émincés revenus dans l'huile d'olive, ail, paprika, tomates pelées ; mijoter 20 minutes) ; saisir les émincés de poulet en

deux fois dans une sauteuse très chaude ; les ajouter à la sauce et cuire 10 à 12 minutes jusqu'à **75 °C à cœur** (contrôle au thermomètre à sonde, valeur de cuisson usuelle pour la volaille) ; maintenir ou refroidir selon la procédure. *Riz complet* : cuire 35 à 40 minutes dans un grand volume d'eau ou au four mixte, égoutter ; s'il n'est pas servi aussitôt, refroidir rapidement en cellule. *Fromage blanc aux framboises* : décongeler les framboises au réfrigérateur, les écraser légèrement, les déposer sur le fromage blanc au moment du service. Points critiques : volaille (manipulation séparée, planche dédiée, cuisson à cœur), riz cuit (refroidissement rapide pour éviter *Bacillus cereus*), chaîne du froid du dessert.

Personne	Adaptation
Monsieur A. (hypertension)	Pas de sel ajouté dans sa part : paprika, ail, herbes et poivre suffisent ; tomates pelées sans sel ajouté pour tout le monde ; on sale le plat commun au moment du service, chacun selon son goût, en goûtant d'abord
Monsieur D. (pas de porc)	Le menu ne contient pas de porc ; vérifier l'absence de lardons, de bouillon ou de saindoux dans les produits ; ustensiles propres
Madame K. (intolérance au lactose)	Fromage blanc remplacé par un fromage blanc sans lactose ou par un dessert au soja enrichi en calcium, avec les mêmes framboises ; certains produits fermentés sont parfois mieux tolérés, mais on suit ce qu'elle sait de sa tolérance

Question 14 – Apports nutritionnels (2,5 pts)

Calcul posé – Apports d'une portion (Ciqual 2025, sel ajouté non compté)

- **Salade de chou rouge et vinaigrette** : 75,8 kcal ; lipides 6,00 g ; fibres 2,24 g ; vitamine C 15,0 mg.
- **Poulet basquaise et riz** : 525,7 kcal ; protéines 35,70 g (dont poulet 120 × 23,4 / 100 = 28,08 g) ; glucides 66,77 g (riz 80 × 71,4 / 100 = 57,12 g) ; lipides 10,48 g ; fibres 8,88 g ; vitamine C 113,9 mg (poivrons 80 × 121 / 100 = 96,8 mg).
- **Fromage blanc aux framboises** : 99,7 kcal ; protéines 7,88 g ; calcium 139,0 mg.
- **Total** : **701,2 kcal** ; protéines **44,48 g** ; glucides **77,03 g** dont sucres **17,08 g** ; lipides **20,12 g** ; fibres **13,29 g** ; sel **0,31 g** ; calcium **219,9 mg** ; fer **1,55 mg** ; vitamine C **138,3 mg**.
- Répartition de l'énergie : protéines 44,48 × 4 / 701,2 = **25,4 %** ; lipides 20,12 × 9 / 701,2 = **25,8 %** ; glucides 77,03 × 4 / 701,2 = **43,9 %** ; le reste vient des fibres (13,29 × 2 = 26,6 kcal, soit 3,8 %) et des arrondis.

Commentaire. Le repas apporte environ 700 kcal : c'est un déjeuner consistant mais raisonnable pour des agents actifs, qui peuvent compléter avec du pain les jours d'effort important. Les protéines sont largement couvertes (44,5 g) avec 120 g de volaille, ce qui répond à l'attente des agents sans recourir à la viande rouge. Les fibres (13,3 g, soit 44,3 % des 30 g quotidiens) et la vitamine C (138 mg, plus que les 110 mg de référence pour la journée) sont très bonnes grâce au riz complet, au chou et aux poivrons. Les lipides (25,8 % de l'énergie) restent modérés et viennent surtout d'huiles de bonne qualité (colza, olive). Le sel du repas sans sel ajouté est très faible (0,31 g), ce qui laisse de la marge pour Monsieur A. comme pour les autres ; tout dépendra du sel ajouté à la cuisson et à table. Le fer (1,55 mg) est sous-estimé, car la teneur du riz complet est notée « < 1 » et comptée 0. Le calcium (219,9 mg) vient surtout du fromage blanc.

Question 15 – Procédure « départ en intervention » (2 pts)

1. **Sécurité d'abord** : le dernier agent qui quitte la cuisine coupe tous les feux et le four ; on ne laisse jamais une cuisson sans surveillance. Un rappel est affiché près de la porte.
2. **Plat entièrement cuit** (sauce et poulet à 75 °C à cœur) : s'il reste quelques secondes, le plat est placé en bac couvert dans le four mixte réglé en maintien au chaud, au-dessus de 63 °C ; au retour, on vérifie la température à cœur (au moins 63 °C) avant de servir.
3. **Si le maintien n'est pas possible ou si le retour risque d'être long** : le référent désigné place le bac en cellule de refroidissement (passage de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 heures, puis stockage entre 0 et 3 °C) ;

au retour, on réchauffe rapidement jusqu'à au moins 63 °C à cœur, en moins d'une heure, et l'on ne réchauffe qu'une seule fois.

4. **Préparations en cours de cuisson** (volaille seulement saisie, riz en train de cuire) laissées à température ambiante : si elles sont restées plus de 2 heures hors du froid ou du chaud, on les **jette** ; on ne termine jamais la cuisson d'une volaille partiellement cuite et laissée à température ambiante.
5. **Ce qui se conserve** : la salade de chou et le dessert, restés au froid.
6. **Prévention** : organiser la préparation pour limiter les situations à risque : sauce préparée d'abord (elle supporte l'attente), poulet saisi et cuit en une seule fois, en dernier ; riz cuit à l'avance et refroidi ; stock de secours dans la popote (œufs, pâtes, conserves de légumes secs) pour un repas rapide au retour.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 16 – Déroulé minuté des 3 heures (2 pts)

Horaire	Candidat	Agents	Point d'arrêt possible
9 h – 10 h	Mise en place, vérification du matériel, affichage de la procédure de départ, cuisson du riz et refroidissement en cellule	–	Riz refroidi : arrêt sans risque
10 h – 10 h 15	Accueil, objectifs, rappel des règles d'hygiène, présentation du menu	Lavage des mains, tenue	–
10 h 15 – 10 h 45	Démonstration de la découpe et de la sauce	Épluchage et émincé des légumes ; préparation de la salade de chou	Légumes émincés au froid : arrêt sans risque
10 h 45 – 11 h 05	Supervision de la sauce	Sauce basquaise mijotée	Sauce sans volaille : couper le feu, refroidir ou réchauffer plus tard
11 h 05 – 11 h 25	Contrôle au thermomètre à sonde	Saisie et cuisson du poulet (référents), contrôle à 75 °C à cœur	Plat cuit : maintien au-dessus de 63 °C ou cellule
11 h 25 – 11 h 40	Réchauffage du riz, dressage, explication de la procédure de départ	Dressage, fromage blanc aux framboises	–
11 h 40 – 12 h	Dégustation, grille, échange	Dégustation et évaluation	–
12 h – 12 h 30	Remise en état, nettoyage et désinfection, relevé des températures, bilan	Rangement	–

Question 17 – Méthodes d'animation et grille de dégustation (1,5 pt)

Les référents co-animent : ils montrent les gestes à leurs collègues (apprentissage entre pairs). Monsieur L. et les autres anciens sont sollicités pour leur expérience (« quel plat de garde faites-vous depuis vingt ans ? ») et chargés d'une étape valorisante (la saisie du poulet, l'assaisonnement) ; leurs propositions de recettes sont notées pour le carnet. On fait un petit défi chronométré (« plat prêt et sûr en 30 minutes ») et une démonstration de la procédure de départ, avec le thermomètre. Grille de dégustation : pour chaque plat, une note de 0 à 10 pour le goût, l'aspect et la satiété (« est-ce que ça tient jusqu'au soir ? »), une case « je le referais en garde : oui / non » et une ligne de suggestion.

Question 18 – Hygiène, sécurité, éco-gestes (1,5 pt)

Hygiène : lavage des mains, tenue propre ; volaille travaillée sur une planche dédiée, mains lavées après ; contrôle de la cuisson à cœur au thermomètre ; refroidissement en cellule et traçabilité des températures ; décongélation des framboises au réfrigérateur ; nettoyage et désinfection des plans de travail. Sécurité : couteaux rangés après usage, jamais dans l'évier rempli d'eau ; manches des casseroles tournés vers l'intérieur ; aucun feu laissé allumé en cas de départ ; sol sec. Éco-gestes : cuisson à couvert ; utilisation des restes (riz en salade le lendemain, en respectant la chaîne du froid) ; achats de légumes de saison (chou en hiver) et en vrac.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 19 – Réalisation (3 pts)

Critères : chou finement émincé et assaisonné ; sauce basquaise réduite, poivrons fondants ; poulet tendre, cuit à cœur (température relevée) ; riz complet cuit, grains détachés ; dessert frais et coloré ; assiette standard généreuse et appétissante ; assiette de Madame K. avec un dessert sans lactose ; poste propre, températures notées.

Question 20 – Évaluation et situations (1 pt)

Évaluation : grille de dégustation (notes et intention de refaire en garde), observation par les référents des gestes d'hygiène et de l'usage du thermomètre, question finale « que ferez-vous si le bip sonne ? » (objectif opérationnel 1), puis suivi de l'utilisation du plat dans le carnet lors des gardes suivantes.

Départ à 11 h 05, retour à 13 h 20. Les feux ont été coupés au départ. Le poulet seulement saisi et le riz en cours de cuisson sont restés 2 h 15 à température ambiante : on les jette, sans les finir de cuire. La salade et le dessert, restés au réfrigérateur, sont servis. On prépare un repas rapide avec le stock de secours (par exemple, une omelette aux légumes et des pâtes), et l'on utilise cette situation réelle pour expliquer la procédure et l'intérêt de cuire la volaille en dernier, en une seule fois.

Monsieur L. et la côte de bœuf. On ne le contredit pas devant le groupe et on ne le met pas en difficulté : « C'est un vrai plaisir, et il a toute sa place pour un repas de fête de la caserne. » On ajoute : « Pour les gardes, on cherche des plats qui supportent le bip et qui ne coûtent pas trop cher à la popote. Vous qui connaissez les gardes depuis longtemps, quel plat proposeriez-vous pour le carnet ? » On transforme l'objection en contribution.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les taux de réponse sur 44 au lieu de 58 et 49 ; calculer la part des fruits et légumes sur le total de l'autre période ; confondre l'évolution en points (+ 12,9) et l'augmentation relative de la part (+ 80,3 %) ; oublier que le coût par repas fait partie de l'objectif spécifique 2 ; présenter les tickets d'achat comme une mesure de la consommation ; interpréter le nombre de mentions comme un nombre d'agents ; présenter le test comme une preuve ; oublier la perte des poivrons et du chou dans le bon de commande ; terminer la cuisson d'une volaille partiellement cuite laissée plus de deux heures à température ambiante ; réchauffer plusieurs fois ; opposer les anciens aux référents.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Calculer les indicateurs de processus	Taux de réalisation, présence, fidélisation, couverture, taux de réponse avec les bons dénominateurs	S1, S3			
Analyser des réponses appariées	Tableau de transition, part ayant progressé, réduction relative	S1, S3			
Exploiter des scores	Moyenne, médiane, gain normalisé, progression par sous-groupe	S1			
Appliquer et interpréter un test	McNemar avec ses conditions, sans en faire une preuve	S1, S3			
Utiliser un groupe de comparaison	Différence des évolutions, risque relatif et intervalle de confiance, comparabilité	S1			
Exploiter un indicateur indirect	Parts des achats, coût par repas, avantages et limites	S3			
Analyser des données qualitatives	Codage, part des thèmes, enseignements, verbatims	S1, S3			
Juger un projet	Six critères de l'OCDE et RE-AIM, argumentés par les données	S1, S3			

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Évaluer l'équité	Couverture des sous-groupes, interprétation	S1			
Analyser un budget réalisé	Écarts, coût par participant et par résultat, règles du financeur, reversement	S1			
Analyser la transférabilité	Fonctions clés, éléments adaptables, conditions de réussite (ASTAIRE)	S3			
Valoriser selon le destinataire	Supports, messages, calendrier, Cerfa n° 15059, éthique	S1, S3			
Concevoir un atelier accessible	Recette en images, adaptations, sécurité, allergie	S2			
Calculer bon de commande et apports	Pertes, conditionnement, coût, Ciqual, répartition de l'énergie	S2, S3			
Évaluer un atelier	Grille d'observation, échelle imagée et ses limites, plan à un mois	S2, S3			
Maîtriser l'hygiène en situation imprévue	Maintien au chaud, refroidissement, réchauffage, ce qu'on jette	S2, S3			